

胡希恕、李冠杰

伤
寒
论
讲
稿
合
订
本

目录

第 1 条.....	13
第 2 条.....	25
第 3 条.....	30
第 4 条.....	43
第 5 条.....	47
第 6 条.....	54
第 7 条.....	80
第 8 条.....	86
第 9 条.....	90
第 10 条.....	93
第 11 条.....	100
第 12 条.....	107
第 13 条.....	128
第 14 条.....	137
第 15 条.....	156
第 16 条.....	160
第 17 条.....	168
第 18 条.....	170
第 19 条.....	170
第 20 条.....	177
第 21 条.....	190
第 22 条.....	190
第 23 条.....	201
第 24 条.....	213
第 25 条.....	223
第 26 条.....	228
第 27 条.....	236
第 28 条.....	237
第 29 条.....	248
第 30 条.....	271
第 31 条.....	276
第 32 条.....	285
第 33 条.....	288
第 34 条.....	296
第 35 条.....	307
第 36 条.....	316
第 37 条.....	316
第 38 条.....	326
第 39 条.....	337
第 40 条.....	337
第 41 条.....	350
第 42 条.....	364
第 43 条.....	366
第 44 条.....	368
第 45 条.....	369
第 46 条.....	374
第 47 条.....	379
第 48 条.....	382
第 49 条.....	390
第 50 条.....	394
第 51 条.....	396
第 52 条.....	396
第 53 条.....	400
第 54 条.....	405
第 55 条.....	408
第 56 条.....	410
第 57 条.....	416
第 58 条.....	418

第 62 条.....425

第 63 条.....432

第 64 条.....439

第 65 条.....447

第 66 条.....456

第 67 条.....474

第 68 条.....474

第 69 条.....474

第 70 条.....474

第 71 条.....501

第 72 条.....515

第 73 条.....517

第 74 条.....522

第 75 条.....524

第 76 条.....530

第 77 条.....542

第 78 条.....546

第 79 条.....549

第 59 条.....551

第 60 条.....551

第 61 条.....551

第 80 条.....551

第 81 条.....551

第 82 条.....573

第 83 条.....581

第 84 条.....583

第 85 条.....584

第 86 条.....584

第 87 条.....587

第 88 条.....587

第 89 条.....589

第 90 条.....594

第 91 条.....597

第 92 条.....602

第 93 条.....606

第 94 条.....610

第 95 条.....614

第 96 条.....616

第 97 条.....630

第 98 条.....637

第 99 条.....647

第 100 条.....651

第 101 条.....656

第 102 条.....665

第 103 条.....666

第 104 条.....677

第 105 条.....684

第 106 条.....689

第 107 条.....703

第 108 条.....709

第 109 条.....711

第 110 条.....712

第 111 条.....718

第 112 条.....723

第 113 条.....728

第 114 条.....730

第 116 条.....733

第 117 条.....737

第 118 条.....747

第 119 条.....750

第 120 条	752
第 121 条	754
第 122 条	754
第 123 条	757
第 124 条	761
第 125 条	770
第 126 条	772
第 127 条	775
第 128 条	777
第 129 条	777
第 130 条	780
第 131 条	781
第 132 条	789
第 133 条	789
第 134 条	794
第 135 条	808
第 136 条	812
第 137 条	816
第 138 条	816
第 139 条	828
第 140 条	832
第 141 条	836
第 142 条	851
第 143 条	853
第 144 条	856
第 145 条	859
第 146 条	862
第 147 条	871
第 148 条	877
第 149 条	885
第 150 条	893
第 151 条	896
第 152 条	897
第 153 条	904
第 154 条	904
第 155 条	904
第 156 条	904
第 157 条	919
第 158 条	926
第 159 条	936
第 160 条	940
第 161 条	942
第 162 条	953
第 163 条	956
第 164 条	966
第 165 条	970
第 166 条	974
第 167 条	981
第 168 条	984
第 169 条	993
第 170 条	994
第 171 条	996
第 172 条	998
第 173 条	1004
第 177 条	1010
第 175 条	1020
第 176 条	1023
第 177 条	1027
第 178 条	1033
第 180 条	1084

第 181 条	1088
第 182 条	1089
第 183 条	1093
第 184 条	1094
第 185 条	1102
第 186 条	1104
第 187 条	1106
第 188 条	1110
第 189 条	1113
第 190 条	1115
第 191 条	1116
第 192 条	1119
第 193 条	1122
第 194 条	1123
第 195 条	1126
第 196 条	1128
第 197 条	1130
第 198 条	1133
第 199 条	1134
第 200 条	1135
第 201 条	1136
第 202 条	1138
第 203 条	1140
第 204 条	1144
第 205 条	1144
第 206 条	1146
第 207 条	1149
第 208 条	1152
第 209 条	1167
第 210 条	1171
第 211 条	1171
第 212 条	1178
第 213 条	1183
第 214 条	1186
第 215 条	1189
第 216 条	1191
第 217 条	1194
第 218 条	1194
第 219 条	1200
第 220 条	1206
第 221 条	1208
第 222 条	1208
第 223 条	1208
第 223 条:	1219
第 224 条	1222
第 225 条	1224
第 226 条	1228
第 227 条	1228
第 228 条	1229
第 229 条	1235
第 230 条	1240
第 231 条	1243
第 232 条	1243
第 233 条	1251
第 234 条	1257
第 235 条	1260
第 236 条	1261
第 237 条	1267
第 238 条	1272
第 239 条	1276

第 240 条1276

第 241 条1280

第 242 条1282

第 243 条1284

第 244 条1289

第 245 条1297

第 246 条1300

第 247 条1301

第 248 条1306

第 249 条1308

第 250 条1308

第 251 条1312

第 252 条1315

第 253 条1318

第 254 条1320

第 255 条1320

第 256 条1323

第 257 条1328

第 258 条1328

第 259 条1334

第 260 条1339

第 261 条1342

第 262 条1345

第 263 条1363

第 264 条1368

第 265 条1371

第 266 条1376

第 267 条1380

第 268 条1382

第 269 条1384

第 270 条1385

第 271 条1388

第 272 条1388

第 273 条1402

第 274 条1408

第 275 条1410

第 276 条1410

第 277 条1410

第 278 条1417

第 279 条1427

第 280 条1434

第 281 条1442

第 282 条1447

第 283 条1455

第 284 条1455

第 285 条1458

第 286 条1461

第 287 条1461

第 288 条1468

第 289 条1469

第 290 条1470

第 291 条1472

第 292 条1472

第 293 条1474

第 294 条1475

第 295 条1475

第 296 条1477

第 297 条1478

第 298 条1479

第 299 条1480

第 300 条	1481
第 301 条	1483
第 302 条	1488
第 303 条	1492
第 304 条	1497
第 305 条	1500
第 306 条	1503
第 307 条	1505
第 308 条	1511
第 309 条	1512
第 310 条	1515
第 311 条	1518
第 312 条	1523
第 313 条	1527
第 314 条	1531
第 315 条	1535
第 316 条	1542
第 317 条	1549
第 318 条	1554
第 319 条	1562
第 320 条	1564
第 321 条	1568
第 322 条	1571
第 323 条	1572
第 324 条	1574
第 325 条	1579
第 326 条	1599
第 327 条	1610
第 328 条	1611
第 329 条	1611
第 330 条	1616
第 331 条	1616
第 332 条	1618
第 333 条	1622
第 334 条	1625
第 335 条	1627
第 336 条	1629
第 337 条	1629
第 338 条	1632
第 339 条	1645
第 340 条	1647
第 341 条	1648
第 342 条	1649
第 343 条	1650
第 344 条	1653
第 345 条	1654
第 346 条	1655
第 347 条	1657
第 348 条	1657
第 349 条	1659
第 350 条	1661
第 351 条	1664
第 352 条	1673
第 353 条	1677
第 354 条	1680
第 355 条	1681
第 356 条	1684
第 357 条	1689
第 358 条	1698
第 359 条	1699

第 360 条1706

第 361 条1707

第 362 条1707

第 363 条1710

第 365 条1710

第 364 条1711

第 366 条1711

第 367 条1714

第 368 条1715

第 369 条1717

第 370 条1718

第 371 条1721

第 372 条1725

第 373 条1726

第 374 条1727

第 375 条1729

第 376 条1730

第 377 条1731

第 378 条1732

第 379 条1735

第 380 条1737

第 381 条1739

第 382 条1775

第 383 条1777

第 384 条1778

第 385 条1782

第 386 条1786

第 387 条1786

第 388 条1796

第 389 条1798

第 390 条1798

第 391 条1803

第 392 条1809

第 393 条1815

第 394 条1820

第 395 条1823

第 396 条1826

第 397 条1828

第 398 条1831

整理说明

为了更好地传承和弘扬胡希恕先生的经方学术，学习李冠杰老师全面辨证体系，现将胡老伤寒论讲稿与李老师康平本讲稿整理汇总于一体。

大家通过阅读就会发现，李老师的学术体系就是完全根植于胡老经方学术体系的，有继承、有发展，完整体现了从六经八纲三毒到十二字经方病理辨证体系的发展脉络。

“新竹高于旧竹枝，全凭老干为扶持。下年再有新生者，十丈龙孙绕凤池。”
——《新竹》郑燮。

在经方的历史长河中，胡老学术的璀璨之光得以再次闪烁，冯世纶老师功不可没，我们都在冯老“做一代经方传人”的殷切盼望中努力成长！正是有胡老、冯老、李老师等一代一代的经方人无私无悔的传道受业解惑，经方才得以发扬光大！

最后以自己当时阅读胡老、李老师讲稿后，窥见经方之门时所做的一首小诗，与诸位同道共勉！

读胡老、李老师讲稿有感

孜孜以求年少时
彷徨无奈岐黄日
仲景之门终得见
至今犹恨识君迟

引用资料：

胡希恕伤寒论讲座

李冠杰康平本伤寒论讲稿

康平本伤寒论（唐宋对照版——李冠杰整理）

经方学术搬运工：袁洪雷

2021年4月20日—2022年8月14日整理于金水堂

胡希恕先生简介：

胡希恕（1898—1984）又名胡禧绪，是我国近代著名中医经方临床家、教育家。被日本中医界赞誉为“中国有独特理论体系的、著名的《伤寒论》研究者、经方家”。胡希恕青年时拜清末进士、名医王祥徵为师学习中医，于1919年参加沈阳市政公所中医考试，获取中医士证书并个体行医，后于1931年在北京个体行医，与陈慎吾、谢海洲等老中医办学，传播中医学术。1952年经北京市卫生局批准，开设北京私立中医学校。1958年调入北京中医学院任内科学教授、附属东直门医院学术委员会顾问等职。胡希恕先生一生治学严谨，只在《北京中医学院学报》和《北京中医》发表过文章。其学术传人卫生部中日友好医院冯世纶教授系统整理了胡希恕先生的部分学术思想，整理出版了《经方传真》、《中国百年百名中医临床家·胡希恕》、《中国汤液经方》、《解读张仲景医学》、《胡希恕病位类方解》、《胡希恕讲伤寒杂病论》、《胡希恕讲金匱要略》、《胡希恕温病条辨拾遗按》等。

胡希恕先生



李冠杰老师简介：

李冠杰，山东德州人，十分推崇胡希恕先生的学术理论，尽心深研六经八纲学说，并进一步发挥，站在先辈的肩膀上，提出了“表里半血水气阴阳寒热虚实”的十二字经方病理辨证体系，用此体系指导临床，纯用经方临床有效率达百分之九十以上。

临床实践的“小剂量免煎中药”即经方散剂，为进一步使用经方和推广经方扫除了障碍。有感于经方式微，故愿为经方大声疾呼，不辞辛劳，不计报酬，于2010年和2012年开始在复兴中医网上进行讲课，并在经方学习历史上首次采取康平本与宋本伤寒论对照讲解的方式解读伤寒论，并形成了97万余字的《康平本伤寒论讲稿》，受到了经方学者及爱好者的广泛关注。目前是中医在线特邀讲师。



辨大阳病

大阳之为病、脉浮头项强痛、而恶寒、 (1)

胡希恕：这一段，后世说是叫提纲啊。什么叫提纲？“提纲”两个字提的对，就是太阳病的纲领。我们更具体的来说，对于这个太阳病，它是一个概括的特征，凡是太阳病它必须有这个特征，那么也就是说太阳病啊，不是一个个别的病，像咱们说的那个现在的病名多了，是肝炎呐，肺炎呐，都是一个个别的病，它是专有一定的致病的因素，一定病变所在的地方，这种现在西医的病名一个病一个病的病名。这个虽然叫太阳病，它不是单独对一个病说的。这个太阳病啊，凡是脉浮，头项强痛而恶寒，有这一系列的证候反映，那么它就叫太阳病。太阳病它就是一般的证，无论什么病，像我们平常见的感冒啊，流感啊，伤寒啊，瘟疫啊等等的吧，它一开始发作都有这种情形，这是我们临床常见的东西了。

脉浮，头项强痛而恶寒，那么具备这种特征就叫太阳病，你就根据治疗太阳病的方法治疗，那是不会错的，这太阳病头一节说的就是这个。我们再深研究，那么根据这些证候，我们来更深入的认识太阳病。那这个脉浮说明什么问题呢？这个脉浮就是脉出来了，往外出来了。它怎么出来的呢？就是血管里头充血了，就是血液多了，所以它脉浮。血液多了就是血里头水分多了，他不是说一得病血倒多了，哪有那事儿啊，是水分多了。

脉浮啊，就是我们身上外面这些浅在的动脉，有高度充血的这么一种情况，脉才出来了，尤其头项这个部位充血更加的厉害，所以在上边特别疼，而且强（qiang），这个强啊，就是强直的样子，这个在书的注里给改作 jiang，这也通。这个强啊，现在河南人说身上哪个地方板啊，他就说强。张仲景是河南人嘛，可见这个强是河南的一个语言，还是对的。那么由于这个充血，是上半身厉害，越往上越厉

害，这个我们在一般的感冒都得过，一得感冒这个脑袋的血管都绷起来了，越往上越厉害。那么这说明什么呢？这个充血，靠着外面浅在动脉都充血，而上体部尤其厉害。“而恶寒”，这个恶寒就是体表热。我们平时的温度啊，他与外面的空气接触有一定的差距，他习惯了，忽然高起来了，与外面差距骤然加大了，就感觉外面的空气很寒冷，这是肯定的，它加大了内外的差距了嘛，就恶寒。那么根据证候的分析，我们还要想一想，这是怎么一个情况呢？人想要出汗，在出汗以前，它血管要扩张，大量的体液往外来，这个时候呢，脉就浮了。而这个发汗呢，人要想出汗呐，都在上体部，上体部面积大嘛。那么这种情形，就把体液大量输送到上体部来了，所以脉也浮了，尤其上边更厉害，头项强痛。那么液体得随着热一起来吧，西医也是这么说法，液体和热一起来，外面的体温就增加，就感觉外面怕冷了。那么我们根据这些症状，就可以看出一些问题来。这是在出汗前期的一个证候，要出汗而没能出汗，它就“脉浮，头项强痛而怕冷（恶寒）”。

这我也查找西医书了，它就是这个样。太阳病是怎么样一个病呢，根据这个证候我们就可以得出这么一个结论，它是要出汗而达不到出汗，这么一种病理现象。这个中医有个传统的看法，这个看法还是对的，中医说正邪交争。所以说如果我们有了病了，我们的机体对这个疾病是要斗争的，它不等着，所以正邪交争，这是在中医中顶要紧的一句话。那么这个太阳病它为什么要出汗呢？这就是机体要通过出汗而解除疾病。就是这么一个道理，这个我们讲桂枝汤的时候再讲，在内经上也有。可见这个表证啊，就是这个太阳病是正与邪斗争，在哪呢？在表。这个机体利用发汗的机能，打算把这个疾病排除于体外。假如要是排出去了，那就好了，可是人这种自然的良能是有限度的，他又往往达不到，达不到就出现太阳病这种情况了，要出汗不能出汗，满上半身充血，所以就有这个脉浮头项强痛而恶寒。这个我们可以拿一本书看一看，这个人身体对病邪的抗病能力不行。这个水分从外边

多了，里头就有空气，所以他容易放屁，这是咱们平常人都能观察出来的。可见人的身体有所刺激，它就要适应它，就与它斗争。那么，有的疾病的这种刺激是相当剧烈的，所以身体呢它就不能够抵抗。假如人身体没有这种卫外的机能的话，就活不了了，怎么样的卫生也不行，这空气中的病菌有得是，人遇到这种外在或内在的刺激，他都起来斗争，所以古人在长久的经验中他说“正邪交争”，在内经中讲的很好了。

李冠杰：这一条呢，《宋本》上的原文和《康平本》的原文是没有什么区别的。至于说标点符号呢，标点符号我们啊，为了保持《康平本》的原貌，最大限度地保持《康平本》的原貌，所有的标点符号都是，基本上都是用的顿号。但是这个标点也不是原著上的，恐怕都不是王叔和点的，这都是后人点的。所以说这个标点符号应该客观地去看，除非必要的情况下，我们不去追究这个句子该怎么断啊，我们就不去讨论这个。

那么这一个条文，如果我们用今天的话说呢，就是说：人体患了太阳病以后的表现为：脉浮，头项强痛而且恶寒。

我们今天也跟大家说一个，我们这次学习活动当中，一个我们想遵守的原则，就是凡是症状，都保持原文的面貌。因为症状要如果说，你再去把它翻译成白话，你比如说啊，这儿是“头项强痛”，那么这个“头项强痛”，如果说用我们今天的话说就是：头部和后颈部僵直，疼痛不适。如果说真翻译成这样的话，实际上跟我们以后啊，我们就把一个经方理论的最基本的平台给它变更了。实际上我们今天没有必要对这些症状再把它现代化了，没有那个必要。关键是一个理解的问题，因为这是一个平台，只有在这个平台上去交流，才更有实际的意义。如果说每个人都有自己的一个解释，那么这种基础的平台也就乱了，咱们就是把那个凡是附注的，用于表达思想的那一部分文字啊，我们把它都翻译成白话。

那么这一个条文呢，后世都把它叫做是提纲。实际上它就是太阳病的基本的特征。我们把常见的疾病划了六大类，其中的太阳病，它的基本特征是什么呢？就是：脉浮，头项强痛而恶寒。这是它的基本特征。

那么这里边“脉浮”，指的是什么啊？就是我们这个桡动脉啊，这个地方现一种浮脉，那么这个浮脉啊，就是轻取即得。你那个把脉的时候啊，手搁到脉上，轻轻地放到上边，就能够很明显地感觉到脉象的形状呢，这是浮脉。当然这个脉呢，我们后边还要再进一步地详细讨论。我们现在就是，因为咱是初学，还得照顾到有一些接触时间不长的，我们呢，是一层一层地往里深入。就是前几条吧，到后来啊，慢慢大家熟了以后，基本上就是到一百条左右的时候，我们再做这么浅显的解释的机会就少了，逐渐地有一个过程。

“头项强痛而恶寒”，说的就是人体的头部和颈部的后部比较僵硬，甚则疼痛，就是这么一个症状。那么“恶寒”呢，就是指的人体主观上老是感觉到怕冷。按我们今天的话说呢，就是怕冷。

那么这个第一条啊，实际上是一个症状群。单纯的某一个证不能确定为是太阳病的一个指征，只有这几个症状同时出现，或者再和其他的太阳病的病症同时出现的时候，才能称得上这个人体患了太阳病了。

我们这次学习，很重要的一个问题就是解决一个方向的问题。那么我们现在在这一条，一开始接触的时候，我们首先要明确一个很重要的问题：实际上经方理论，我们理解经方理论，就应该彻底地而且是原原本本地理解经方理论的本来意思，而不是做毫无依据的乱延伸。

那么这儿呢，说了几个典型的症状：一个是脉现浮像，再一个是头项强痛，而且怕冷这么几个典型的症状。如果这几个典型的症状同时出现，出现在同一个人的身上，那么，我们就把这个人，表现为特

定的症状群，作为疾病反应出来的这个人体呢，我们就说他患了太阳病了。

我们这多年来，都把这个解释成什么啊？做了延伸，根据内经的理论做了延伸，说什么这是人体的太阳经出现问题了，而且太阳经，是足太阳膀胱经。那么也做了一些必要的解释。为什么说它是足太阳膀胱经而不是手太阳小肠经呢？是因为，这个足太阳膀胱经在人体上是循行线路最长的一条经络，它遍布人体的后部，从头到脚，所以说呢，就是它得了病了。它呢，主人体一身的体表吧。

实际上，经方理论里边不是这意思。就是说这个人体患了病以后，你不管患了什么病，也不管你哪个地方病了，只要是表现为这样的基本的症状特征，那么，我们就认为他是得了太阳病了。咱在这儿为了容易理解啊，因为这个地方是最容易弄混淆的地方，就是说，人得了病了，是以这样的症状反应出来。那么到底他哪儿得病了？所有的人都会有这样的疑问：他哪儿得病了？不一定。这是古人从临床实践当中总结的非常重要的，而且到目前为止，现代医学仍然没有认识到的一个规律。而且这个规律呢，它符合事物的本来面目。

咱比如说，像桂枝汤。桂枝汤的治愈疾病的记录里边就有胃炎。这个胃炎与体表有何关系呀？与足太阳膀胱经有何关系？如果要是那么去理解的话，你把这个太阳病理解成人体的足太阳经病了，你真正这么去理解，那么在临床当中真要是如果说有一个人他是桂枝汤证，而且他有胃炎，你在医院或者检查胃炎，或者他在主述的时候说胃里边怎么不舒服，甚至拉肚子。要是这样的情况，你还能想到用桂枝汤吗？那还有里证在那儿搅和着呢，还有太阴病在那儿搅和着呢，阳明病在那儿搅和着呢。所以说你到那个时候，为什么后世用经方的人越来越少？就是因为在这些基本点上就弄错了。我们再换一个角度说，要如果说我们古人他想说太阳经病了的话，那么他直接说太阳经络病了，不行吗？在张仲景写《伤寒论》的时候，五百多年以前，《内

经》就已经成书了。他直接写明了太阳经络病了不行吗？为什么说太阳病呢？所以说，他本来不是那个意思。大家就不用那么理解，不要那么去理解。

而且经方里面还有一个重要的特点，它对疾病的界定，是按着人体患病以后的症状反应来界定的。尽管在《金匱要略》里边，有一些按脏腑来界定的。比如说，肺痿、肺癰之类的病。也有一些按着疾病的特征来分类的。那都是什么呀？那都是为了行文的。就是说他得把问题说清了，所以说才用了那么一种方式。再加上呢，在于我们客观地说啊，经方这本书已经将近两千年以前的书，在当时这一套理论应该说不是那么特别的健全吧。咱其实要如果说，真正要是按我们今天这么理解的话，也许当时的人就会把所有的方子都分了这六大类疾病里边，然后可以再分一分类嘛。在这些不同的疾病里边，再就按着前边我和大家一块儿讨论的，可以按那几大项分一分类。因为咱们现在你看看经方里边，辨寒热、辨虚实、辨水、辨血、辨气，都有。那么古人没有按着那种方式分类。为什么呀？就是因为那么描述也相当困难，把那么复杂的问题，要如果说写到竹板上的这种方式，把它写清楚也是个挺困难的事。所以说呢，古人没有这么说。但是，我们通过整体地来看，凡是有点经方知识的人去看看，经方里边你看太阳病，有些地方你看“头项强痛”，确实这些部位都在足太阳膀胱经里边。但是其他的，就不对了。

冷，它是一个地方的吗？怕冷是一个全身的症状，是不是？那么这个“脉浮”，“脉浮”你也很难说“脉浮”就是膀胱经病了证据呀。这也不是很确切。但是呢历代的注家很多很多都是这么去理解。就觉得这个部位确确实实就是膀胱经循行的部位。事实上啊，不是那样。因为我们结合临床实践刚才说了，那么它治的还有胃病，事实上古人本意不是那个意思。要如果说再那么理解了以后，最终的结果就是到最后，经方就不会用了。这是一个问题。

另外呢，我们再从病理上看一看，这几个症状，如果说不是太阳经病了，那么按我们今天理解的话，这几个症状从病理上应该是什么样的？它到底是怎么一回事儿？那么“脉浮”，这个“脉浮”啊，我想用一个比较形像的现象啊，给大家说一说，可能好理解一些。大家看一看我们肢体上的血管，特别是手面上的血管。这个血管你要如果说仔细观察的话，它会出现什么情况？这几天，它非常饱满，哎呀高出皮肤来，看看又那个很明显的，这当然跟人的胖瘦有关啦啊。这几天这样，但是过了几天之后，又看了这个血管啊，特别的这个跟皮肤平了，甚至有时候都近似于凹进去。这是同一个人在比较短的时间之内，就是几天的时间，它就会出现这种情况。那是什么原因呢？有的人呢，在这方面他们通过长期的观察解释得非常好。就是我们这个血液啊，本身的循环是一个密闭的系统，是一个循环的过程，但是它是一个密闭的系统。不同部位啊，这个血管的饱满程度的不同。会有至少这么两个方面的原因：一个方面的原因，是这个血液分布的量在变化，比如说，这个肝脏在它恢复的过程当中，你这个手的血管就会比较干瘪，就比较瘪。那么为什么？因为肝脏会在它的恢复的过程当中，会耗费那个血，需要血液的量就比较多。我们怎么去理解这个事儿？就说肢体上能看到的部位，如果说我们偶尔有什么东西撞击一下，一下撞了很疼，然后呢，后来就发红甚至发紫。发红是什么意思？然后它这个地方还会那个很热，就是温度高，然后呢，它就慢慢地再恢复。实际上这就是它在恢复的过程当中，它就需要大量的血液。而且呢，遭了撞击造成这个局部的组织的损伤呢，也有这一方面的原因。那么，它在恢复的过程中，需要大量的能量，这个时候呢，血液在这个地方集中得就比较多一些。所以有人就推这个理，就是我们内脏里边有时候它在恢复的过程当中，也会需要大量的能量，那么它占用的血液多一些。因为我们身上的血是有数的，所以说内脏里边占得多了，外边四肢分布的就相对要少一些，这是一种解释。我觉得还是有一些道理

的啊。

另外一个呢，就是血液里边含的水分。血液里边含的水分多了，也会造成这样的情况。而且这个血液里边含的水分呢，也可以有不同部位，量也有不同。

那么这样呢，这个“脉浮”，“脉浮”我们首先说一个啊，“脉浮”不仅仅是太阳病有，得在“恶寒”或者是“头项强痛”这一类的症状佐证之下，同时伴有这一类的情况，那么这个“脉浮”，我们才可以认为它是一种太阳病的疾病反应。那么这个“浮脉”，说明什么呀？说明血液携带着大量的体液都集中在人体的皮肤下面，也就是说集中在肢体的外部，它想通过发汗的过程，最终实现恢复肌表功能的目的。这个时候因为表证本身，就是说我们的浅表组织这一块儿，状态不太好了。这里边就有一个问题了，大家可能会说，你一直说经方理论讲的是症状，它讲的不是具体的病变部位，那你为什么又回到了人体的肌表组织的功能问题？人体是一个整体，患了病以后，以什么样的症状表现出来，说明了它是哪一类的疾病，但是具体的病变位置不一定。

可是我们又回到刚才说的那个桂枝汤治胃炎，你吃了桂枝汤以后也要有那一个程序，微微出一点汗，其实表也解了，胃病也好了。为什么会出现这种情况？那种胃炎，有时候会以腹泻的形式表现出来。为什么会出现？因为人体是一个整体，它出现了浅表性的疾病，但是它里的部位又是一个薄弱的环节，人体还有能力再恢复体表的状态这个能力。所以说，这里边就有一个，尽管具体病变的位置不同，但是它的疾病性质确实是浅表性疾病。为什么？因为凡是表证都需要用出汗的这么一个过程，就是“汗解”，它才能治愈。

所以说根据这个，再加上现代医学对感冒的研究当中，也对表证做了一个很好的解释。这是“脉浮”，也就是说当人体的血液携带着大量的体液集中在体表的时候，这个时候，你再摸摸脉，就比较饱满，

给人一种“浮脉”的脉象。

这个“头项强痛”，“强”也可以念“jiang”，这里边这个“头项强痛”，因为“头痛项强”这一类的症状不仅仅是太阳病，其他的疾病也有。你比如说痉病，跟这个就比较类似，实际上用的药也是，葛根汤嘛。我在这儿说，我们有时候把古人对症状的描述，应该说经方里边对症状的描述非常地精道，我们得细细地去体悟。

我在这儿就这个“头项强痛”这个症状，我给大家说一说很常见的现象：我们有时候，咱比如说吧，你衣服上面掉了个扣子，或者说很早以前的时候都自己做衣服，到缝纫社里去做，做完了以后，扣子要自己钉，你要做一点针线活。平时我们特别是男士很少做针线活，你要做一点的时候，你看这个姿势，低着头，这有时候一个扣子钉不下来，你就会发现后颈部疼，但是有时候你甚至一个小时多，在那儿一直认真地做，它也不疼。什么意思？为什么这次疼，其他的时候又不疼呢？这时候你这个人体恰恰有了表证的倾向，但是它没有发展到非得感觉是疾病那个程度。你要细细体悟一下的话，你可能会有某些不太舒服的感觉，但是很轻，像那一类的，有可能你要喝上一碗热汤面，略微出一点汗，身体比较好一点的，也会好了的。

但是我在这儿想说什么呢？两方面：一个是这个“头项强痛”，跟其他的在程度上就不一样，这种“头项强痛”不是说特别得剧烈。所以说古人用的这个词也非常地有意思，你看，不单单不是特别地剧烈，就这儿这个“强”，本身就带有僵硬的意味。但是呢，它必须跟葛根汤里边那个“强几几”要区别开来，它还没有那么重。为什么我刚才给大家举那个做针线活的例子？因为这种不适，不至于说难受得受不了，只是感觉到它有这方面的头疼。当然人跟人不一样，有的人可能头疼得稍重一些，有的人可能后脖颈不适拘急稍重一点，但是他也不一定达到了那种程度。当然葛根汤证也是太阳病的一种，如果说葛根汤证和麻黄汤证比的话，麻黄汤证出现后背颈部的不适感就没有

葛根汤证那么集中、那么强烈。大家要慢慢去体悟，它这种症状本身不难理解，但是它大概是一个什么样程度，这很重要。

这一点，也就是说把经方的论述跟我们的临床实践要结合起来，不能把它束之高阁，你就算把它都背过，也不管用。那么这个“头项强痛”说明了什么？说明一个是得了表证，就是人体处在表证的病理阶段；另外一个还得人体有自愈的趋势，尽管它一时自愈不了，但是它有自愈的趋势。这种趋势是什么样的一种趋势？是自下而上、自里而外这么一种趋势。你看表证，几乎没有下肢的症状，一般都是自下而上有一种生发扩张这么一种趋势。

那么我们现代医学的研究，就说它实际上想把外界的致病因子通过这种方式赶出去，或者说我们换一种说法，它就是想把大量的能量输送到体表，想在体表恢复它正常的状态。但是这个恢复的过程，它要形成一种不适于外界致病因素存在的环境，它这样人体就形成一种自下而上，经方里边叫“气上冲”，就形成了这么一种趋势。而且这种趋势是人体的一种本能。那为什么？我们现在可以说，没有什么为什么，这是人体的一个本能。也许这种为什么在几十年几百年以后，人们通过现代医学的方式和手段可以把它研究透。但是我们现在没必要去追究那么深，就说它就是形成了这么一种趋势，我们治病也正是利用、帮助，也就是强化这种趋势。

这个“恶寒”，也就是怕冷了。至少有这么两种原因：一个原因，凡太阳病都有发热，体温增高，它就会加大我们人体的温度（和外界温度的差别）；这里边有一个，外界的温度的变化是按照它的规律变化，可是人体始终是在外界的变化的条件下，我们正常情况下，体温维持在 36.5℃ 左右的样子。但是当我们患了表证以后，人体想恢复正常状态的过程当中，形成了一种高温，要提高基础体温，提高以后就加大了我们人体和外界的温差，以前我们适应的是那样的环境，可是当人体的体温提高了以后，相比之后就感觉环境的温度低了，人就

感觉到有点冷，这是一方面的因素。另一方面的因素呢，我们是不是还可以这么理解：就是说这时候的人体，他把大量的能量都用来调节体表的状态，所以说呢在人体体表的正常直觉这一方面呢，就会出现误差，那么这样呢也会造成误判。但是这个误判的结果是什么？就是我们人，感觉环境冷了，老是怕冷，就是说不禁冻。这是一个恶寒的机理。

这个太阳病本身它就是一个人体在自我恢复的过程当中，表现出来的这么一种疾病。人体是自我恢复的过程不错，有这种趋势，但是它不一定能恢复。所以说，实际上不仅仅是太阳病，任何疾病都不外乎这三个发展方向：一个是它自己恢复了，自愈了。在太阳病里这是很多的。就是说我们经常说的感冒抗几天抗好了。还有另一种情况，就是说它抗不好以后，就不抗了，它的正气啊，也就是说人体的抵抗力啊，就会进一步地萎缩到更深层次的机体里边去，如果说再进一步地衰弱，它就会出现新的疾病。那么这一次就放弃了，这一点很重要，往后我们还会讨论。还有一种呢，就是他会维持一种表证的状态很长时间，这个我们后边再详细地讨论它。

在这里，我们说一个具体的医案，这个医案呢，很多人都知道。那么用意是什么呢？我们今天说这个医案的意思就是：想再强化一个意识，就是说：太阳病千万不要认为人体患了病以后，就是人体的肌表得了病了。为什么？因为现在这也等于说是受了脏腑辨证的影响吧，很多人现在看啊，治皮肤病，就是基于解表剂，把解表剂一个或是若干解表剂给加减得乱七八糟，然后呢用来治疗皮肤病。像这种治疗方式，我们说它不一定没有效，一个是疗效不是很好；再一个，大家想想，如果说这个人得了皮肤病，它不是表证，你按着表证去治，这个皮肤病有可能好啊，为什么？因为它是在强化肌表这个环节，所以说在这个环节过程当中，可能某些表证，你再加上一些相关的一些药，肌表的功能在强化，然后呢发生在体表皮肤的某些疾病，可能就

随之消失了。但是要如果说这个病的根源在里边，大家想想，实际上这等于说是误治。

那么说在皮肤上得的病怎么可能会在里边，我记得我为这个单独的跟大家讨论过一个我自己的医案，就是说用理中汤治粉刺，要如果说他有理中汤证的话，那简直就是一绝，几天就好，连五天都不到就好。当然，没有理中汤证吃了是没效的。那么这也就是说大家去看看理中汤何以解表啊？它何以治皮肤病啊？所以说这才是真正的经方！一定要脱离开具体的病变部位。

但是，我们也不得不承认一个问题，就是经方的表证跟体表部分组织的、功能的不正常、失常，是有最密切的联系。尽管具体的病变不一定发生在这儿，但是你只要是人体表现为这样的症状，你吃完了以后让他出点汗，他就好了。

那么我们这儿有一个医案，就是用麻黄汤治疗难产。大家可能都知道有一个很著名的医案：一个孕妇，临盆的时候出现难产，怎么着也生不下孩子，后来找了几个医生，用一些近似于我们今天催产的药，都无效。后来一个我们现在说的经方高手，看了一眼，把把脉问一问，说这人按我们今天的说法，这人感冒了，麻黄汤证，给麻黄汤。一剂麻黄汤下去，一会儿微微地出了点汗，浑身轻松，孩子马上就生下来了。说这个事儿，解表药催产？这是不可思议的事儿。那么它的机理其实也非常简单，人体这个时候出现了表证，人体把相当大的一部分能量都集中在解表，恢复肌表的那种状态，所以说它就没有足够的能力让这个孕妇把孩子生下来。包括我们现在的医院里边，有的接生的老大夫，就有这样的经验：碰到有一点难产老生不下来，他问一问之前吃的东西也不多，就是体能不足，他会让她喝上一碗红糖水。有时候就一碗红糖水就解决了。从这一点上看就能看出，人体的疾病不像脏腑辨证认识的那样，也不像现代医学认识的那样，说哪一个地方病了你就按哪一个地方治。不一定！

经方医学给我们找到一个规律，就是你要看他得病以后是什么样的症状反应，我们就把它界定成什么疾病，你就按照这个疾病去治。治了以后不管病变的位置是什么，不管具体的疾病是什么，治了就能好。

大阳病、发热汗出恶风、脉缓者、名为中风、（2）

胡希恕：这个太阳病，就是指第一条的“脉浮，头项强痛而恶寒”这样的太阳病的证。那么假如它又发热汗出，这个汗出不是大汗出，得感冒也出现这个，身上潮乎乎的出汗并不太多，而且这个汗啊，觉着有臭味，发热，不但恶寒而且还恶风，这个恶风比恶寒厉害。

“脉缓”，缓者和紧脉是对脉，这个紧脉就像烟卷一样，裹的很紧，你要是倒出去一半，这个烟卷就是缓了，你按着软不塌的，就不是那么硬了，这叫缓。为什么脉缓呢？就是因为出汗了，出来了，水分水分就，丧失一部分了，所以这个脉一按就缓了。那么后面要讲的伤寒，它就一点汗都不出，它的脉就特别紧。那么这一段它说太阳病里头有这么一种太阳证：发热，汗出，不但恶寒还脉缓，这类的太阳病就叫做中风，这个风在古人的意思就是风邪了，就是中的风邪了，这是错的。它是因为怕风，所以古人给它起名叫中风，其实它就是个类型的问题。我们前面讲的太阳病要出汗达不到出汗，才有太阳病这么一种情况，这会儿它见汗了，应该好了，但它没好，这就是出汗的机能的关系了。

这个汗达不到驱除疾病质和量的问题，虽然出汗但不能解除疾病，而下面的伤寒干脆就达不到出汗的目的，就这么两种情形。那么古人说中风，那就是拿现象当本质，这是古人的一个错误。古人嘛，像仲景的时候，两千年来科学水平在那呢，现在咱们不能这么说了，现在把中风当一个证名看就是了，并不是真有风邪在这里，可是因为这个名字的关系对于解释就成问题了，我们过后再谈，现在先不说这

个。

那么说这个中风，这个“中”字上是有用意的，这个“中”就是拿箭射东西谓之中，中者中于内，这就说明出点汗而邪却留到里面去了，你出汗表就虚呀，可是表虚……（音频缺失）这个部位，所以古人叫中风。中风者，言其邪深也。这个邪就是病邪了，在表的部位较伤寒要深，所以用这个“中”字，这个“中”字是很有意义的。但这个风邪的说法，现在不要这么信了，不要说恶风就是风邪，这个恶风它是因为出汗，身上有热又有汗，非恶风不可，这个洗澡大家都知道，从热水里出来，出一身汗那就是怕风，你非披上点衣服不可。它这个身上热又有汗那就要恶风了，他不但恶寒还恶风，所以恶风比恶寒厉害。由于恶风，古人说是风邪，这风邪是不对的。但是这种证不妨碍我们治疗，假如太阳病就是脉浮，头项强痛而恶寒的这个病。它有脉缓，发热汗出这一类的太阳病（就是中风证），这个病邪比较深，不在皮肤这一层，在肌肉那一层。古人有句话：“邪之所凑，其气必虚”，由于外表出汗了，皮肤疏松，所以这个邪乘着这个虚，它就往里面去，到哪呢？它进不到太里面，就在肌肉这里面，所以后面我们要讲了，桂枝本为解肌，不叫发表了，这是第二条。

李冠杰：这一条，用我们今天的话说，就是患上太阳病以后，表现为发热、汗出恶风、脉缓的，我们就称其为中风。

实际上讨论的是太阳病里边，一种表虚证的典型症状反应，因为它有汗出。这儿我们需要明确一点，这里的太阳病，就是指的太阳病提纲第一条的“脉浮头项强痛而恶寒”，它得有这一类疾病的基本特征，不一定那三个症状样样都有，但是基本的特征得有。在这个基础上，它又有它自己的特点。所以说这一条里边的太阳病，我们以后这一类的情况还很多。

凡是这种冠以太阳病这样的条文，都是指的它有某些太阳病的基本特征，或者说从外貌上看，貌似太阳病，最起码得是貌似太阳病。

而它呢一看像是太阳病，但是呢仔细再一看呢，它还有太阳病以外的症状，他再给你去界定。这是古人比较特殊的那个表述方式，它可以减少好多文字。

但是这样呢，跟其他的不一样，这不是讨论其他类型的疾病，它就是说这里的太阳病不是那种意义。它就说在太阳病的基础上，我们再讨论一种有汗出的脉浮而缓；这儿呢，提出了“发热”，就说人体温已经高了。你看这个“发热”，因为后边桂枝汤里边说得很清楚，就“翕翕发热”，那么这种发热一般体温不是很高。

你看大青龙汤也发热，小青龙汤也可能发热，包括柴胡汤也可能发热，那个桂枝汤、麻黄汤几乎都有可能出现发热。但是我们在这儿讨论的，就是要跟临床联系起来，这是一种什么样的发热？它比大青龙汤证、比那个麻黄汤证一般地说要轻一些，体温没有那么高。人呢，感觉也没那么难受，所以“翕翕发热”嘛，就好像羽毛罩着它，形像地说好像是夏天穿上了羽绒服，有点热。

另外一个“汗出”，这个汗出呢，也不是那种大汗淋漓的汗出，它只是微微地出点汗。

今天碰到一个小孩子，他说老鼻塞，嗓子里边有点痒了，又发烫，咳嗽，甚至咳嗽完以后有点疼。我就给他看了看，我说你喜欢出汗吗？因为你像小孩这类的病，首先想到他一旦咳嗽、嗓子又不舒服，那么首先想到什么？小柴胡汤合上半夏厚朴汤，那咱不能主观有这种想法带着这种有色眼镜去看，你最终要凭证。那么就问了，所有的柴胡证都没有，然后又问，出汗吗？他说早晨起床以后就特容易出汗，已经是十来岁的小孩，我说那这样吧，给你按按肚子吧，因为我看他舌体有点胖的，所以说我在考虑他是不是有用茯苓甘草汤的机会。那么我就去按他心下的地方，按的时候他这地方一点都不跳，但是，按的时候就发现他身体潮乎乎的，这就是比较典型的有汗出。不一定是大汗出的那种，这儿说的也不是那种汗出。这个小孩子我最后就给他用的

是什么？桂枝加黄芪汤，然后又加上了茯苓、白术和桔梗。因为是今天看的吗，以后看他疗效什么样子，再给大家汇报结果。

他呢，明显有停饮，就是他那个脉象，这个小孩的脉象偏了沉了，再加上舌的胖大，晚上基本上没有小便，就等于说小便不利了。所以说给加了去水的药。

再就是“恶风”，这个恶风啊，古人描述症状非常严谨，大家说这个“恶风”和“恶寒”有什么区别？那个“恶风”就是，用我们现在的話說就是对空气的流动比较敏感。他怕冷吗？恶寒吗？也恶寒。但是，尤其稍微有一点点风他会比较敏感，比没有汗出的人他觉得温度变化大，他怕冷更厉害。

这个“脉缓”，应该是在浮脉的基础上有，应该是个脉浮缓。因为太阳病提纲里面“脉浮”已经有了，那么这个地方呢，你看古人写东西就是，他能省一个字，就省一个字，又见前面就有了。这不仅仅是一个省字的问题，就是说这是古人的一种特有的叙述方式，就是在别的地方他已经说到了，他在这个地方就不重复了。实际上这条前边已经有了，有了太阳病了，那么他的脉应该是个浮像，“脉浮、头项强痛而恶寒”嘛。那么这里又特意地跟你说，他在浮脉的基础上这个脉现于缓像。那么这个缓呢，就是我们把这个脉象比作自行车内胎的话，就是气打得还不是比较饱满，按一按，就比较软弱一些。

这个“名为中风”，这一点非常重要。这说明什么呀？大家看看，对中风而言，中风这个词显然不是经方家们创造的，是大家约定俗成的。在很早以前，在《黄帝内经》上就已经对这个有了很明确的界定。那么在这儿呢就是“名为中风”，说得非常客观。我们仅仅把这种现象叫做一个名字，叫做中风这个名字。为什么把它叫做中风名字呢？因为就跟我们今天说的风热感冒、风寒感冒是一样，大家、社会上的医生都约定俗成了。都认为这一类的是人体中了风了。那么，这些经方家们却不那么认为，他并不认为这个时候是人体真的中了风了。但

是大家又对这种病都这么称呼，那么我们在这也没有必要再给它起一个新的名字，就把这种现象、这种病理反应，称作中风。

所以说这个地方如果说深究的话，这些经方家们，历史上的那些经方家们，对问题的分析认识相当得客观。他们没有认为这是人体真的中了风了，我就把它叫作中风，大家都叫中风，我们就把它起这么一个名字。言外之意就是说这不是人体中了风了，人体是患了这样的疾病了。可是对这样的东西的解释，后来的人对人体中寒也好，中风也好，那些解释简直是花枝招展、五花八门了，什么样都有。甚至在医案里边就非常明显地去附会那些东西，说这个人劳作以后，然后躺在床上睡觉，晚上起了风以后，后来第二天就感冒了。感冒以后就变成桂枝汤证，喝了桂枝汤好了。它就在强调风对人体的作用。但是有的人就大门不出二门不到，甚至就是产妇她连窗户都不敢开，一点风都没着，她也得了桂枝汤证。你又做何解释？根本就不是那么一回事。

所以说，理解经方理论常常很容易出现偏差，因为经方给我们是一个结果。那么你对这个结果怎么认识，那是你的事，这些经方家们不给你去解释。特别是我们大家通过看《康平本》就能明显地看出，就是王叔和离张仲景的年代那么近，从那个时候他就开始误读，而且误读得厉害。大家你去看看，要如果说王叔和的观点，要跟那个《汤液经》的观点和张仲景的观点比较接近的话，我们根本就没必要费那么大的劲，再把一个《康平本》弄来弄去，再去校对，再去费那个劲干什么？《宋本》就非常全了。可是真正是按照这个分开以后，大家去看看，那简直就不是一个理论体系

那么这一条说的是一个表虚证。表虚证的病理特点是什么？就是说人体啊，为什么我们刚才一直在说这个表证就是人体的体表组织的功能失常了？尽管有时候，他的病变部位不一定在体表，但是，只要是以这种症状反应出来，你治了它（表证），所有的病都会治愈，或者说减轻。那么所以说，这个时候的主要矛盾就是表证的问题。那么

我们现在说的这个表虚证是一个什么问题？表虚证实际上是人体体表，如果说相对表实证的话，就是人体体表功能的不足，就它表现为一种不足。但是不足的结果是什么？造成了人体汗腺的失控，就开而不合，他合不上。所以说人体在恢复体表功能过程当中，体表的这些水分体液，他就出现的不正常的流失，因为汗腺该闭合的时候，没有完全地闭合上。所以说，人很容易微微地有汗出。

那么这个表虚证的“恶风”，还有从机理上说，刚才咱们说的的是一个“汗出”的问题，之所以有汗出，就是因为人体的体表处于一种相对不足的状态。那么他就没有能力把毛孔正常关闭，这时候就表现为汗出。那么“恶风”，古人把它叫做恶风，实际上就是说，这汗出了以后，体表的水分相对就多了，体表的水分多了以后，这个时候空气一旦流动加快，蒸发的水分就多，水分蒸发得多了以后，带走体表的能量就比较多一点。而人体对自然界的空气流动就比较敏感。我们说这就是“风”嘛？这就是说对“风”的敏感程度就比较高。

“脉缓”呢，也是在这个基础之上。“脉缓”就是因为人体汗腺的闭合功能不能正常实现，然后体表的体液就有所丧失，那么丧失以后，血管里边的血液充盈程度就没有表实证那么高。所以说呢，这个脉呢，摸起来以后虽然是个浮脉，但是比较缓一些。就是说，血管没有那么饱满，没有那么紧张。

大阳病、或已发热、或未发热、必恶寒体痛、呕逆、脉阴阳俱紧者、名曰伤寒、（3）

胡希恕：这太阳病证啊是表阳证，是迟早要发热的。不过开始得的时候，或者已经发热或者还未发热的时候，有的人一有病了头疼等等的，看病的时候还没发热呢，可它转手就要发热。无论已发热还是未发热，必恶寒呐，一定是怕冷的，所以这个恶寒是表证的一个特征，它一定怕冷，而且不汗出的这个怕冷特别厉害，在临床上也是，麻黄

汤证比桂枝汤证的怕冷要重的多，尤其是大青龙汤证，冷的更厉害。

“体痛、呕逆”，他一点也不出汗，这个人的气息不得旁达，你像桂枝汤证他不是不往上撞他也撞，但轻，所以也有干呕啊。而麻黄汤证他一点汗也不出，气息一点也不往旁走，他都往上撞，所以它呕逆。

那桂枝汤证身体不是不疼，也疼，但它疼的轻，那血管不是缓了嘛。这个伤寒是无汗，他这个充血不光往上面冲，他哪面充血都比中风重的多，所以身体都疼，不光头项，这就是有汗无汗的关系，有汗脉缓无汗脉紧。

这个阴阳俱紧就是上下脉全紧。这个紧啊，你拿手一按脉，非常的界限分明。这类太阳病就叫伤寒，就是太阳伤寒。那么古人取这个名词跟中风一样，也是由于这一类的太阳病必恶寒，恶寒比中风显著，所以他就叫伤寒了。那么古人管这个有汗的叫做中风，没汗的叫做伤寒。这个古人限于当时的科学水平，我们现在就不应该这认识了，还要说什么风伤哪儿了，寒伤哪里，这明明白白的，现在都是常识了，不是什么科学专门的事了，还要那么讲就是错了。

可是这个“伤”和这“中”这是要分析的，所以仲景的文字都这样。他起个名字，你看“中风”与“伤寒”，这也是很有味道的。“中”，这个邪深。“伤”者，伤于外。咱们擦伤、碰伤，都是伤于表皮，这个伤寒是皮表不开，汗不得出，所以一发汗就好了，他就是人体的病邪浅，这叫做伤寒。

这三条，头一条讲的是太阳病的提纲，也就是概括的特征。那么这种太阳病再细分，有两种，一种太阳伤寒，一种太阳中风。主要的差别，一个是汗出，一个是无汗。由于这个汗出和无汗，这个证候就不同了。

李冠杰：这条从字面上看，这个“名曰伤寒”在《宋本》里边是“名为伤寒”，没有什么质的区别。这可能是在王叔和二次整理的时

候，发现这个地方不太工整，他没有什么质的区别。“名曰”、“名为”没有质的区别，要假设说没有这个名字，那整个问题就变了，那这实际上是一个意思。

那么这一条，我们用现在的话说，就是说人体患了太阳病之后，或者已经出现发热，或者还没有出现发热，但必会发生恶寒的症状；然后呢，身体疼痛、呕逆；脉呢，是整个脉均出现“浮紧”的这么一种脉象。我们把这样的症状反应，称为“伤寒”。

这一条论述的是一种阳性的表实证的典型的症状反应。跟前一条一样，也是在太阳病提纲的基础之上。就是患了太阳病以后还有这样一种类型，表现为“脉浮、头项强痛而恶寒”的同时，又出现了脉既浮又紧而且怕冷比较明显，身体疼痛、呕逆这一类的症状。有的可能是体温已经很高了，有的可能体温还没有增高，但是，很快就可能出现体温高。因为这儿就有一个“或未发热”，这种描述方式就非常有意思，我们今天很少用这样的方式来叙述。就是或已经发热，或已经发热就体温已经高了；或未发热，或未发热还有言外之意，他还没有发热呢，他必定会发热。那么这个，也符合太阳病提纲的基本的病理特征。

这个“或已发热或未发热”，咱们已经讨论。但是这个发热，一般表实证的发热，临床上这个病人得表现出来。我常说这句话，病人得病没有按书本上得的。这病人表现出来的，往往有时候，也许发热不是很明显，甚至不一定发烧；有的呢，发烧也可能不是那么重；有的就是特别得重。发烧到什么程度啊？就是人恶寒得打哆嗦，摸摸头上有点烫手，摸摸身上都烫手，有的烧到40多度。但是，一般的表虚证呢，一般不会高烧到这个样子。这里边就是说表实证和表虚证这个发热，还是有一点区别的。再一个呢，临床当中表实证往往来得比较急。我自己闹了一个，大概前后也就两个小时的时间吧。那时候我在北京，坐公共汽车，上公共汽车的时候，只是觉得说不出来，早饭

以后只是有点说不出来得不太舒服，去办事，办完事回来，哎呀，在那个车上，一会儿不如一会。结果到下午就开始高烧了，就是烧得挺厉害。

这个表实证的这个发烧啊，常常是一个比较典型的症状。特别是大青龙汤证的那个发烧，当然大青龙汤也有不发烧的啊，有的就是说表实停饮的那种，以停饮为主的，有可能体温还不高呢。就是说经方难，难在哪呢？就难在这个地方。所以说，我们经方的核心和基础就是方证。

那么，如果说我们把所有的经方，都给它界定一个很全的方证范围不就完了嘛。实际上临床当中，我们现在找这种资料有的是啊，在好多书上就有。我这儿有本书，就是经方配伍用药指南。这本书上，就把经方所治疗的现代病，每一个方子所治疗的现代病，每一个方子所对的症状都有。因为这都是客观地统计的嘛，相对地说也比较全面，这是相对的啊。但是，就这个你拿到手里边，不会用经方的依然不会用经方。它经历很多方面的因素，总的说，在临床当中，人得病，不按着书上去得。我说一种我们现代的解释，常常每一个症状，都尽可能地去解释病理，便于你在辨证当中去用它。

那么，下边“恶寒体痛”，这个“恶寒”呢，表实证，表实证的“恶寒”跟体温的升高关系是非常明显的。这个“体痛”，所谓表实证，它的特点是什么？就是因为机能偏于亢奋，而且这种偏于亢奋，它实际上也是一种病态，偏离健康的，离健康的体表功能的话，已经有一定的差异了。但，它这种病态呢，表现出一种过度的亢奋，那么，过度亢奋的结果是汗毛孔闭而不开，这汗毛孔闭住以后啊，他没能力打开，打不开了，实际上就是说功能失常了吧。打不开以后就怎么样呢？人体在这个恢复肌表的这种趋势下，把大量的体液血液送到人体的体表，这个时候每一个血管里边，甚至包括毛细血管里边，微血管里边都充满了前所未有的，一般情况下没有的，那么高度的、充盈的

体液和血液。所以说身体的神经啊，就产生一些压迫，这时候就会感觉到疼痛，这个“体痛”是这么来的。

这个“呕逆”，我们在临床当中啊，恐怕是现在见到气上冲这么厉害的不是很多。就是说本来呢，人体患了表证以后，就有自下而上气往上来的那么一种趋势，那么在这种趋势下，再加上几乎全身的毛孔闭合，用胡希恕的话说，就是气不得旁达，就是没有其他地方可去。所以说在消化道就会表现一种，都有上逆的一种感觉，就是想吐，你看表虚证也有时候会出现干呕。

这里的“脉阴阳俱紧”，也是在脉浮的前提下。这个“紧”，就类似于脉体的轮廓非常得清晰，而且呢，这个脉体紧张有力，这是一种紧脉。简单地说实际上就是一个浮紧的脉。那么，这个浮紧的脉，也是跟表实证的疾病机理相吻合的，就是因为人体大量的体液血液都在血管里边，把整个血管胀的饱饱的，就跟那个自行车内胎一样，把那个气打得非常饱满，所以说你摁的时候就非常硬，就是这么一个道理。

那么，这名为“伤寒”，跟那个“中风”是一样的。但是，这个“伤寒”有着更重要的一层意思，大家去看一看啊，咱们好多其他的中医理论里边，都有一些那种近似于人伤于寒，寒附于人体，怎么怎么样，很多类似于这样的论述。但是，在我们学经方，就不要那么去认识。这里的“伤寒”，仅仅是一个名字，而不是人受到了那个外来的寒邪，就是由温度造成的。

我想啊，咱们现在表实证、表虚证，我们都讨论到了，而且，太阳病，整个的太阳病我们也讨论了。那么，这到底它是一种什么样的，我们应该怎么去认识它？它跟传统医学的一些理论是一个什么样的关系？它和现代医学的理论是一种什么样的关系？它到底是一个什么样的疾病？我们刚才已经基本上分析得都比较透彻了，它就是跟人体的体表机能失常关系比较密切的这么一类疾病，它主要表现的就是

“脉浮，头项强痛而恶寒”，这是最典型的。然后在这个基础之上，有一种是虚证，有一种是实证。

要如果说细究的话呢，我们后边学习会发现，这个虚证和实证之间，有时候还会出现错杂的情况。就是说既有虚证的成分也有实证的成分，这是客观现实。人得了病就会这样，他就是这个样子。

那么经方里边说的这个太阳病，我们刚才已经说了，我们一定要把它跟某某脏腑得了病了，或者说是某某的具体的部位发生了病变了和某经络发生病变，一定要分开。这是我们需要分开的，我们讨论的是什么？我们关注的重点是什么？就是这个人得了病以后他的疾病反应有太阳病的基本特征，我们就可以断定他是太阳病。至于说他具体的病变部位是在哪儿，具体的病变性质是什么，不重要。所以说这样呢，我们在临床当中啊，常常就跟我们治病的过程当中，跟病人在医院里边检查的结果和病人的主诉常常是不吻合的，你不能让他们给误导了。

另外一个呢，就是我们要能把经方的理论和其他医学的理论分开，这一点非常重要。要如果说这样啊，可能大家会有这种想法，你是不是非得要标新立异，搞一套另类的东西不可啊！我也不想去辩解什么。

我在这儿就跟大家说一个老生常谈的问题，大家时刻得去想这个问题，为什么经方理论这么好，经方的方剂这么好，到现在，实际我们现在社会的现象是什么？就是用经方的医生几乎达不到实际临床医生的百分之一，或者说现在肯定达不到百分之一。而且，就是你怎么用经方都可以，也不一定非得是全用经方，你主要用经方都可以啊。为什么？我们没有其他意思啊，不是说别的方剂不能治病，没有这个意思。就是说你本来能用经方治的病，你用了别的方剂，你就把一些好的方案给抛弃了，渐渐地，实际现在是已经把整个经方理论经方的方剂都束之高阁了。人人都说它是经典，人人都说它好，但是人人都

不用。不是说他不想用，就是因为在理论上出现了偏差，在理解上出现偏差，他不会用啊，他用来用去他就出事，那还能用吗？那就是不能用。所以说我一直在强调这个问题。而且像这个问题，我们要是在学习当中碰到合适的点，会再不断地跟大家强化这样的意识。

另外一个呢，就是说这个现代医学。如果我们今天讨论这个表证跟现代医学是一个什么样的关系？他是现代医学的什么病啊？他不是是一个具体的病。

那现在，我说一个，这是前天的一个病人。因为我这儿病人，都是靠病人的口口相传来的。然后他听别人来，他就来我这儿看病，他主诉呢：就是咳嗽感冒了，他说感冒，咳嗽。后来，你看我问他，然后发现他的症状啊，咳嗽有汗、气喘短气，然后呢，舌质胖大有齿痕，再就是脉呢，他的脉可以说是浮缓，但是 you 仔细摸他那个脉，他有洪大的那个脉数，有洪大的那种趋势。这个人呢，就比较相对他有汗出，平时动不动就出汗，而且那个睡觉的时候还自汗也就是盗汗。到最后呢，我就给他用的什么方剂呢？用的是麻杏石甘汤合上泽泻汤。为什么合上泽泻汤呢？一是有水证；再一个呢，他老说，他整天那个脑子不清醒，老是觉得跟头上蒙着一块布一样。这是典型的泽泻汤证，就给他用的这个方剂。这个方剂他拿走了以后，他是我们这临近县的，到了第二天他就开车过来了，又拉了他的妻子，把她妻子拉来。他见了我以后，他说我本来是想，因为来我这看到我这地方不太像治病的地方，因为像是跟个办公室一样。他后来就说：我本来想吃吃你这个药怎么样来着，结果呢，我昨天吃了以后啊，今天我这个鼻炎啊，我只是给你说流鼻涕鼻塞，我鼻炎好多年了，而且现在鼻子也透气了，咳嗽也不咳嗽了，喘也不喘了，浑身都觉得很轻松，就是头脑也清醒了。他说我这才吃了一次药。他说这样我就别再等着试了，我就把我爱人拉过来了。

就说这个啊，他有表证吗？也有表证。要如果说在医院里边看的

话，就是典型的感冒了，就是感冒。可是我们用经方观点来治呢，这里边就相当复杂了。他既有水证，又有里热，还有表证。你要是如果说单纯给他解表的话，或者说单纯治感冒，治不好的。所以说他的鼻炎好多年了治不好，为什么？就是因为都是误治，那治不好的。

但是他这个脉象啊，需要跟大家说一下。他的脉，你要是如果说按当时除了脉滑数之外，那个脉体啊，接近一个平脉。但是仔细感觉感觉，就是说那个血流啊，来势比较猛，就是说他洪脉的那种特征。但是他为什么不表现洪大脉呢？因为他有水证。水证常常会出现一种沉脉，沉脉和那个洪大脉结合到一块，实际上我们这么说啊，他有一部分水证。本来这个人体是想把这些，特别是有里热的情况下啊，他把水分包括蒸发，包括那个恢复肌表，这个脉应该现洪大脉的。但是呢，他就是因为里有停饮，他没有那么多的水分送到肌表来，所以说这个脉啊，出现不了洪大，这个脉就这么来的啊。

这儿呢，就是顺便再说一下脉诊的问题啊。我前两天，青岛有个学生跟我说，他说我这儿有一个病人有那个子宫肌瘤，他说我给她吃了一些什么药。后来呢，我把把脉，她那个肌瘤还在那儿。大家听好像是一个脉诊高手了啊，这叫微观脉学。我想是这样啊，大家去看看经方里边，我们把王叔和的，因为王叔和是研究脉的，他那一部分呢，先把搁到一边。大家再去看一看经方里边的所有的脉象，都是一个总体的脉象，很少有所谓的微观脉象。为什么？因为这里边其实有一个非常简单的道理。就说我学生的这个事吧。我们且不说他摸出来的那个子宫肌瘤准还是不准。我们就算他，我们就认为他准。因为这个脉呢，本身从那个人体全息穴的角度上来讲，这一个脉象通过人体的这一段桡动脉的血管，它的那个变化情况，它会从某种程度，反映人体的一个整体情况。这就像那个张颖清老师写的人体全息学说，非常有意思。他就举一个比方：你比如说啊，像那个杨树，杨树的树冠的形状就跟一个杨树叶那个形状特别相似，而且呢你看杨树叶上那个叶

脉呀，也就像那个分出来那些树枝似的，是吧？就比较相似。或者说，你从具体的一个部位往往能够从某种程度上反应了全局的一个概貌。从某种角度上来说，就是这个脉诊啊，它是个比较客观的指征，不受病人主诉，自我感觉不准确的影响。而且这个脉诊呢，它也确确实实，跟疾病有一定的规律性的联系，它能反映疾病的某些特征。但是呢，我们不能把脉诊绝对化。那么，我就用一个简洁的方式来说吧，如果我们想从脉上摸出哪个人，哪个地方做过手术啦，哪个地方发炎啦？你是肾炎哪，还是肝炎哪？你不一定摸出来呀。就算是摸出来以后，那么你能最后出个方子吗？根据你摸的这个脉象，就像我这个学生他摸这个人有子宫肌瘤，那么子宫肌瘤用什么方剂治呢？方剂对的是什么？对的是症状嘛。经方理论是这样的。

实际上啊，中医的理论这才应该是基础呢。那个归经是什么？咱们今天不讨论那个。以前曾经跟大家说过那都是一厢情愿的不符合事物的客观规律。客观规律在哪儿？方剂、药物跟人体患病以后的症状，有着铁的对应关系。啊，那么这个症状，它跟某个脉象有铁的对应关系吗？不对呀！而且跟症状也不是某一个症状，都是一个一个的，每一个方剂对应的都是一个症状群，都是一个特定，所以叫某某方剂的适应证嘛。所以说，你单纯的一个脉象，你是没法用药的，不管你摸得多么具体。我们从换一个角度说，你摸得那么准确，无非就是代替了医院里边的设备嘛。那到医院检查不就完了吗？像肝炎哪，胆囊炎哪，包括子宫肌瘤啊，到医院里边做B超，在什么部位，多大，都非常准确。有用吗？要如果说能凭这个治病的话，那治好的人不多的去了吗？大家都可以用经方治病，它没有这种对应关系。

所以说，我们不说他能不能准确地摸出来，咱就说你冲着那个方向去努力，咱们社会上这种医生太多了。就我刚才说的那个病人啊，他就跟我说，他说，哎呀，我在很多地方看过了，还碰到好几个那样的中医，不让我说话，给我摸了脉说得还特别准，我还特别相信他。

结果他给我药以后，他说好几个这一类的医生，结果他给我药以后，吃了不管用啊。他说，你这儿的药，吃了管用，我第二天，就拉着我的爱人就过来了，这就是事实。所以说，去冲这那个方向努力，等于浪费自己的生命。

经方里边讲的是一个整体的疾病，一个单独的脉象，一个单纯的症状，都不能成为用方遣药的这么一个可靠的证据。所以说，这个方向是不对的。那么要是有人说，我这个脉就能摸到比医院里边的那种设备检查出来的还要准确，甚至或者说赶上它。那没关系，这也是一技之长。但是，我们的目的是要治病，我们不单单要知道他是什么病，还得要会治病，这才是最终的目的。这是那个扯得远一点了。

刚才说了太阳病跟现代疾病，我们在学习经方过程当中，还有好多人解释说，就类似于现在的感冒，其实不能这么简单地说。感冒里边，包括太阳病，而且呢，太阳病里边也包括一部分感冒。所以说呢，不能这么界定。

就是说中医这个，就经方理论对疾病的界定，你很难用那个现代医学的界定，包括脏腑这种界定呀，很难去给它划等号，因为界定的方法不一样。所以说呢，没法直接划等号的。但是这里边，我们可以有所借鉴。

那么，咱们现在就是通过刚才的学习，我们有一个共识：就是太阳病跟体表的机能状态失常有非常密切的关系，或者说，这是这种疾病的基础。那么要如果说是这样的话，这个肌表怎么了？我们现代医学研究发现，我们现在这个肌表啊，人体正常情况下，我们人处的这个社会环境里边，就是在我们生活环境里边，体表或者能够触摸到的、碰到的这些环境的东西：细菌啊、致病因素啊，数不胜数，多的没办法。假设说这个环境里边没有这些致病因素，一个是不可能，假设说真有了，你人体的抵抗力也很快就消失了。就像到南极一样，到南极以后，那人抵抗力弱到什么程度啊？大陆上去一个供给船，卸一点东

西，他每个人都得感冒。我们现在以感冒为例，现代医学研究这个感冒呢，是人体在抵抗能力弱的时候，这个感冒病毒通过肌肤进入我们的细胞，在细胞里边它自我复制，这个病毒非常小。但是呢，现代医学把这个东西呀，看得很清楚，可是他没有办法，就是说到目前为止，因为现代医学是對抗性的，既然是病毒进入细胞了，我们的目的就是要杀死细胞里边的病毒。可是呢，现代医学却杀不死。据到目前为止，全世界所有的，人类还没有找到能够杀死进入细胞里边病毒的那种有效的药物，一个杀不死。你要如果杀死它，你要连细胞一块儿杀死。杀不死，怎么办呢？从这个意义上说，我们在这儿就是言重了一点。从这个意义上说，在我们中国，不应该允许现代医学治感冒，因为他们的理论。人家说得很清楚，一点都没有虚假，就是说我的目的就是要杀死病毒。但是感冒病毒一旦进入细胞了，我一个也杀不死。那杀不死怎么办啊？我就是用一些别的办法：比如说你鼻粘膜发炎了，流鼻涕，我给你消消炎，让你这个症状缓解一点；那么你发烧了，我给你退烧。人家药的名字解释也很清楚，缓解感冒症状，我没说我治感冒。但是这些缓解感冒症状，同时都有相当大的副作用，其实是得不偿失。那个感冒病毒始终在那儿。

但是，我们从经方理论上，其实这是另一个方向。我们关注的哪一个方向啊？既然这个病毒杀不死，而且我们在生活当中又没法与它隔绝。那么怎么办呢？我们看人体，整体来看好多人，他也生活在这种环境下，他却不得病。为什么啊？那就是因为他有足够的抵抗力，有免疫力。但是这一点，现代医学不去解释了。那个病毒，大家想想能在细胞里边复制。它得小到什么程度？非常非常得小。这么小的病毒，我们的皮肤连汗液都能流出来，病毒想进去那不是轻而易举的事儿嘛。

就换句话说，我们整个的肌肤对病毒来说，就等于说是敞开的大门，从物理的角度说，没有一点的抵御能力。为什么平时很多人都生

活在满是病毒的地方，他反不得病呢？就是因为人体有足够的免疫力。这种免疫力形成了一种病毒进去了以后，受不了的环境。那么也就是说，我们刚才看这个表证要发热，实际上发热就是要形成一种不适合病毒生存的一种温度的环境，再加上人体的免疫功能，就把病毒赶出来，最终以出汗的方式，再随汗液就排出体外。但是出不动汗，那么这个时候，我们中医治病就是，他当初没有认识，但是通过经验发现，人凡是有了这样的疾病反应以后，“脉浮，头项强痛而恶寒”，有汗出的，就用桂枝汤，桂枝汤下去以后，桂枝汤就能帮助人体实现这个目的。人体本来是想最终达到出汗的程度，把肌表的功能恢复了，把治病因素大致都排除体外去。但是出不动，人体没有那么大的能力，桂枝汤吃进去以后，它就能够提高这方面的能力，然后让他实现最终恢复肌表功能的一个目的。

这个问题只是从感冒这个角度，从现代医学也给我们它对感冒的研究，我们来用它显示一下经方的治疗机理。这是一个非常科学的治疗疾病的办法，既没有副作用，大家看桂枝汤里边所有的药几乎都是，都跟食物差不多。尤其是那个姜汤：生姜、葱白，或者弄一点大枣，再放上红糖，这不全是食物嘛，它没有副作用。但是，它却能起到帮助人体实现我们现在说叫解表（我们现在学经方嘛），实现解表的这样一个目的。但是，实际上问题还要复杂得多。人肌表功能不正常了，肌表的功能失常了以后，它引起的具体的疾病，却并不一定这个病就在肌表里边，它还有可能引起其他的疾病。像刚才咱们说的难产就是最典型的一个。难产跟表证有什么关系啊？但是这个时候，毕竟人是一个整体，肌表这儿一旦出现了病态，人体还有这种趋势去恢复肌表的时候，它会需要大量的能量。这个时候如果说在其他的部位出现薄弱环节的话，它有可能发生某些病变，以那个部位的形式表现出来，就像桂枝汤里头可以治疗腹泻。桂枝汤可以治疗腹泻，他得有桂枝汤证，既表现为桂枝汤证，又有腹泻的这种，桂枝汤可以治疗胃炎嘛。

实际就是什么啊？肌表这儿需要大量的能量，然后里边比平常更虚弱一些，病变的具体位置反倒反应在里部。

所以说，我们千万不要把它混同，与现代医学的混同，与脏腑辨证的混同，都不要混同起来。你混同来、混同去，最终的结局就是不会用经方了。

就是紧紧抠住这个疾病反应症状，这是我们学经方的一个核心点。要是我们从这儿入手的话，可以告诉大家，比通过任何途径，学任何医学，都成熟得快。换句话说，经方实际上你要如果说走对了路，实际上是一个比较好学的医学。

那么第4条，前边三条呢，在《康平本》上都是顶格排版的内容。顶格排版的内容呢，从我们现在知道的这个史料上看，我们就简单地把它认为是《汤液经》的内容。那么这三条之后，从第4条开始，出现了退两格排版的内容。那么在我整理的就是横排版的这个本子呢，这个就是楷书，用楷书大字标记的这些内容。我想是这样啊，要是如果说咱们也简单地认为的话呢，我们就把它简单地认为这是王叔和加上上去的内容。但是我想是这样：咱们不管是谁写的，这都是古人留下来的一些财富，我们都应该客观地去看、实事求是地去看。凡是好的东西，我们应该继承的都尽可能的继承下来；凡是不好的东西，我们应该客观地把它分析清楚、引以为戒。

这里呢，就是说因为我对经方关注的时间也比较长了，关注度呢，也高一些。我最近几年基本上就是停止了所有的社会活动，除了一些必须的以外。全部的精力都投在这上面。所以说呢，有一点点体悟。那么我现在体悟的是什么呢？经方这些理论啊，其实我们现在有两个东西是已经定死了的：第一个，就是《伤寒论》和《金匱要略》当初张仲景写完了以后，是一个什么样的面目？我们不得而知了，这已经是不可能的事情了。那么我们今天看到的基本上就是，当然我们把那些残卷之类的特殊的情况排除出去，总的趋势是什么？添加的内容

多，所以说这对我们来说，就有很重要的一个任务是什么呢？就是最大限度地去还原经方理论的本来面目。因为后来的实践证明啊，添加的这些内容有好多东西它确实起到误导的作用，对经方的理解啊，起到误导的作用。

实际上我们现在学经方啊，更大的任务是要用减法而不是用加法。大家去看那个，你像《桂林古本》，那是典型的加法。它最基本的理念是什么？《伤寒论》这么多年了，然后很多地方已经不是太全了，哪个地方会缺少什么东西，咱再补上；它可能还应该有什么东西，咱再补上。补来补去，其实补得越多，误导越大。

现在看呢，我们从前人研究经方的实践来看，并不是说古人传给我们、传下来的东西不够用的，而是误导太多。

伤寒一日、太阳受之、脉若静者、为不传、颇欲吐、若躁烦、脉数急者、为传也、（4）

胡希恕：伤寒病，一开始的时候全发生太阳病，所以说太阳受之，不过这个话是有语病的，什么语病？还是说是开始得病时太阳经受邪有热这个味道，我们现在不要这么看了。那么就是不管是伤寒病，就是感冒也是如此的，一开始得都是太阳病，尤其第一天。如果脉平静，平静是怎么的呢？就是不特别大，不特别快，这都说明病轻，一般轻病都是这个样子，这样的病是不会传的。什么是传呢？仲景的书是这么讲的，开始病在外，它往里边传，传入半表半里，传入里。虽然开始在太阳病，一看这个脉象比较平、静，这个病不要紧，吃点什么发汗药就会好了。吃点感冒冲剂，桑菊饮，甚至喝点姜汤就能好了。

假设说“颇欲吐，若躁烦”，“颇欲吐”就是内传少阳病的情况，这个少阳病，尤其柴胡证是心烦喜呕。“颇欲吐”这个“颇”字很有意思，不是说这个人，有点感冒，稍稍的有点吐的意思，颇就是很的意思，心理闹的慌，要吐。

“若躁烦”，这个躁烦哪，阳明病，这个热在里头人就发烦躁，烦躁的厉害，这个躁搁到上面，躁者乱也，烦是个热像，发烦热，这是有内传阳明的一个证候。而脉又是数急，数就是快，急更快，就是快的厉害，这说明这个病与上面的病差太多了，这个病必传，来势挺凶。所以我们遇到这种病，你这个大夫必须在这个病的一开始就应该知道它的轻重，传与不传。这个要传即便你就是治的对，治的正确，依法来治的，也不会马上就好的，所以对这个病要重视了。这个病也正在急剧变化之中的，临床上千万要注意。假如有脉数急什么的，说明这个病是往前进展的，它没停止。这你得要注意了，尤其是临床的大夫，你要勤看一看，这肯定是要必传的。

李冠杰：这一条是降两字格条文，一般认为是王叔和写的。

那么从字面上看，这个条文是什么意思呢？我们作个直译，就是把它翻译成白话：得伤寒病第一天，为太阳经络发病，如果脉静者，即使疾病不再传其他经络；如果很想吐，又燥烦，而且脉数急者，为病欲传其他经络。这就是大致的意思。

但这里边有一个问题啊。大家一听呢，马上听出一个问题来。我们在这儿直译呢，就用了一个，原文是“太阳受之”，那么我们把它翻译成什么呢？翻译成“太阳经络发病”。说人家没有说经络，这不是强加于人吗？但是，你要是把这个条文前后看一下，再加上其他的条文，你就会发现它实际说的就是这个意思。而且还有一个很重要的佐证，就是在《金匱要略》里边，是《金匱要略》的第一篇，也就是第一卷，胡希恕就一直认为，它是王叔和搞的，里边呢跟经方不单单是语气、文风不一样，而且呢，理论观点也不一样。那里边呢有这么几句话，它说呀，这个人得病不外乎这么三种情况：那么其中呢，就叫什么“不越三条”。其一咱就只说第一个得病的情况：“经络受邪入脏腑，为内所因也”。这个地方就说得很明显了啊，就说经络受邪。那么实际上啊，我们从《康平本》上明显地看出王叔和在拿到《伤寒

论》，就说他在得到《伤寒论》这本书的时候，他发现这本书太好了，他持一种非常崇敬的心情去整理它。但是呢，他看了以后，他也发现，这么好的书，为什么在理论上不到位呢？这是我自己的体悟啊，我就感觉王叔和大概是这么一种心态。为什么在理论上不到位呢？因为他自认为他学了很多，他本身，就是王叔和本身就是以《内经》理论为基础的，他自己的医学体系就是以《内经》的理论为基础的。所以说呢，他在这儿就加了这么一条。

而且如果说，我们凡是了解《内经》理论的，大家都会知道，《内经》里面有对疾病发展传变的规律的内容，就是说王叔和加的这一条呢，他呢是站在《内经》的理论的角度，来解释经方理论。所以说这里面好多东西呢，实际上，别看就这一条里边，就这么简单的，文字不多，但是从理论上来说，相差很远。《内经》代表当时医学主流的理论，那么就是说，得了伤寒以后，第一天得病是太阳症状，那么第二天要传到阳明，第三天要传到少阳，一直传下去，最后传到厥阴。然后，七天以后再传回到太阳。那么像这个啊，我们先不管它对与否，但是我们现在要弄清楚的，就是我们的经方理论不是这样子的。咱们后边条文里边都有。像疾病什么时候会有可能由太阳病发展为少阳病，那么，日期上不一样，而且呢，经方理论在这方面都不是个准日子，那都是用一个大概的日期来说明病变的趋势。

那么现在呢，我们再看看条文里边，我们也学习一下，看看里边这些合理的方面和不合理的方面。

本身他说：“太阳受之”，他是有所指的。指的是什么？就是指太阳经络得了病了。刚才我把《金匱要略》里边王叔和写的一部分内容拿到这来，他说是“经络受邪入脏腑”，这个《金匱要略》里边有这样的内容。实际上，跟这个地方是一脉相承的。从这点上呢，和经方理论是一不致的。

那么下边的内容，我们还是要分析。比如说：“脉若静者”，简

单地把它等同于一个平脉。那么这个平脉，人得了病了，脉象里边没有明确的反映，说明什么？说明这个病势不是很严重。所以说呢，它完全有可能像我们前面说过啊，说这一类的太阳病有可能你喝上一碗热面呢，或者说是甚至洗个热水澡啊什么的，出一点汗，也许会好的。或者说待上那么几天以后，人体如果说没有其他的变化的话，人体可以自愈。所以说像这个呢，一般就认为不会引起其他的疾病。这儿呢就“为不传”。这个“传”呢，我们现在经常把它说成是疾病的传变。那么疾病的传变，我们今天看，参照现代医学的研究成果，就是因为当时的知识层面，它还认识不到，也没法认识到现在的这种疾病传变的真正意义。但是我们今天来看，就不要认为这是表证一路往里传，传到半表半里再传到里，不是。咱们就不要这样去认为了。这实际上是什么啊？是人体初患病，得表证，但是表证，如果说人体的抵抗力不断地衰减，不单单没有实现抗病于外的目的，而且呢，连自己以前的阵地也开始丢失，所以它一再地往里边收缩。那么会进一步地引起其他器官的，就是说内脏器官的某些疾病。哪个内脏最薄弱，就首先在哪儿患病。

你比如说，可能是肺炎啊，可能会是肝炎啊，胆囊炎啊。现代医学证明，这样的疾病，不是感冒的致病因子长驱直入直接引起的。有自己特定的一个范围，有它自己的特定的致病因素、致病因子。所以说这个“传”，今天我们再认识这个“传”的话，就不要那么认识了。这叫什么？这应该算是疾病进一步地发展了，没有向好的地方发展，而向重的地方，进一步加重了。就是发展为其他的疾病了。那么这儿呢，就是从临床当中非常有意义的啊，要如果说你碰到一个病人，他有病，但是你摸他的脉，他的脉比较平静的话，最起码他当时没有太大的问题。而且这个人这个时候，他自己感觉也是比较好的时候。

去年吧，有一个临近县的小孩子，他父母带他过来治病。来以后说，前一天啊，感冒了，感冒了以后发高烧。发高烧以后呢，吃了一

点退烧药，昨天晚上出了点汗，今天早晨，孩子看着精神也好了，体温也不高了，但是呢，就觉得他的病还没有好，所以说就带着他来我这儿看，还有点咳嗽。后来我给他一把脉，我说你这孩子啊，他来的时候是上午，我说你这个药啊，就在我这个地方，我给你用水泡上，然后呢，倒到他的杯子里边，我说你带着，路上就让他喝，你那孩子很快就要发烧。结果，他回去以后就给我打电话，他说，上了车以后不一会儿，孩子慢慢又烧起来了。这是什么道理呢，就跟这一条说得非常相似啊。就是因为他那个脉啊，就是急数啊。你看这个脉，后边这里有：“颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也”。实际上这在临床当中啊，就非常有用处。尽管他得的不是什么重病，但是他要是脉跳得真是很急。那么这里边啊，还有这个“颇欲吐”，就是很想吐的意思。那么很想吐，这儿隐含的有，有可能发展为少阳病的那么一种趋势。因为王叔和他在整理上，他已经做了比较深入的研究了。那么说透了，他还是要《内经》的理论，用《内经》的理论来解释《伤寒》。那么“颇欲吐”这是有可能发展为少阳病。那么“若躁烦”，这个“躁烦”有里热的倾向了。或者说是想吐的那种感觉，或者说是躁烦的那种感觉，这一类的症状，这一类的说法呢，经方里面还不是很多啊。你像“颇欲吐、若躁烦”，在经方的其他条文里头这种说法不多。但是，就是这个意思，就说有可能，要如果说有了少阳病和阳明病的那种苗头，再加上“脉数急”，脉跳得很快，疾病呢，就有可能进一步发展为其他的疾病。我们现在要如果说这么认识的话，这个条文呢还是比较后边这一部分，从“脉若静”往后这一部分，它有一定的道理。但是前边这个“太阳受之”啊，无论怎么解释，“受之”本身啊它得有主体者，它指的就是太阳经络，这与经方理论是不通的。

伤寒二三日、阳明少阳证不见者、为不传也、（5）

胡希恕：上面说的是开始，一日。这个说过了两天三天的时间。

那么如果这个病传，一定是有征兆的，传哪儿去呀，它由表往里传，或者传阳明，或者传少阳，而阳明少阳证一点都不见，肯定它不传。

那么这两段我们看的虽然是太阳表证，那么你对这个病的轻重缓急、传与不传，当大夫的也要心里有数。怎么来观察呢？那么不外乎在脉证。开始二三天不传，那它肯定是不传。这个我们在临床上常看到的，二三天这个病就传少阳的多，人也无力了，发烧不退，脉浮细这类情况。你看他胸胁满闷，柴胡证这就来了，这个病较为重。那么二三天还不传，肯定这个病还是不要紧的，就是一般的伤风感冒了。

李冠杰：这一条呢，是把上一条的意思又进一步地明确化，而且又进一步地深入了一下。这一条呢，在《康平本》里边也是降两字格排版的条文。其实，跟第4条也是一脉相承的。

那么我们把它直译一下：患伤寒两三天的时间，如果没有阳明或者是少阳病的症状发生的话，就说明了疾病不会发生传变。就想说这么一个意思。

太阳病提纲提醒大家注意后边那些经方理论里边，比如说“太阳病四五日”怎么样怎么样，都不太符合《内经》的理论。《内经》的理论是怎么样啊？是在第二天、第三天就可能会传到阳明或少阳，真实意思就是这么一个意思。要是如果说没有这个意思的话，这些条文反倒是多余的了，加它就没有什么意义了。

像这个呢，我在前边已经说了，客观地说，疾病的传变，特别是我们今天，凡是有临床实践的人都有这样的常识。实际上这个疾病的传变啊，它没有一个特定的日期，你看后边经方，凡是那个正宗的经方条文啊，它对日子的论述大部分都是活的，都是活说的啊：四五日、三四日，很少，也有一些，比如说就说些具体的日子。但是如果说纵观全书，包括《金匱要略》对日子说得死的，把疾病的这种传变规律弄成机械地、准确日子的话，全都出在王叔和的条文里面。实际上这都是从《内经》上套过来的，就是那么机械地去算。如果说我们要

是看一看临床的话，我们首先说啊，在临床当中，我们可以这么调侃地说，我们设一个奖励基金，去奖励什么？奖励那些从临床当中，发现了这个人第一天得病的时候是太阳经受病的，那么第二天马上就是阳明经又受病了，第三天少阳经，那么七天以后又回到太阳了。谁见过这样的病例？如果说谁见过，我们就奖励给你，谁都没见过，这都是在临床当中。

那么其实我们这么想，我们也不能把古人这些东西贬到那么低的程度，也许他是想拿这事儿来你给他打圆场，都很难打。他也许是在想，也是用日子的形式来说这个疾病发展变化的规律。可是就是这样的话，你不要在第七天的时候再传回太阳啊。你又传回去了这个事儿，那么你只能是说这个人可能，这个人得病啊，常常是由浅入深，那么深来深去他可能会自愈了。自愈后，以后再得病，可能还是要先从浅表性疾病开始。他是不是想说这么一个意思？但是我们现在就很难去，就是解释起来，都觉得很困难。

所以说，像这一类的，我们就很难把它跟真正的临床结合。结合临床来学习经方的话，你很难把这些东西跟真正的经方的临床实践结合起来。

那么还有一个，就是我们在临床过程当中，实际所有人都会有这样的体会，这凡一个疾病啊，没有一个准确的日子。你看谁敢说人得了病了，他几天以后肯定就会得胆囊炎？或者说他肯定会得肝炎？肯定会得那个什么肾炎什么的？就算是他“脉数急”，他有那些明显的症状，比如说：他有“喜呕”啊，或者说也有“烦”哪，但是也不一定真正就发展到那个程度。而且有的太阳病，一个太阳病桂枝汤证持续了二十年的时间，这二十年也真够长的。所以说，就是那种机械地去认识，有害无益。我们今天呢，要避免这样的认识法。可是咱们要如果说你真正地去看看那个经方理论的条文，它有一些具体的内容，但是，它的日子不是死的。而且呢，你从那个日子里边，明显地能感

觉出来，就是想用那些日子给你，想用最少的文字说明最多的问题。它想给你说一个疾病发展趋势的这么一种方向。

那么我们在这儿啊，通过这两条的学习呢，我们再稍微地延伸一下，澄清一些问题。

就是说我们现在，反正我现在有比较深的体会。那就是说我们现在所接触得很多的理论、很多的方法，包括我们中医里边很多的派别，没有哪一个说是一点道理没有的。都有自己的道理，它存在都有它存在的价值。

所以说我们今天学经方，这是我们必须要正视的问题，而且必须要弄清的问题。其实我们现在，我们用一个不太讲道理的一种说法，咱比如说，现在有时候某中医大师说，胡希恕先生前无古人后无来者。为什么？因为他一生研究经方，一生在临床当中基本上只用经方看病。但是，很多人听到这个话就不愿意听。为什么？其他的中医、时方就不能看病吗？就很自然地提出这样的问题。其实时方也能治病，而且好的时方医生，治病的疗效也是非常好的。时方里边也出了好多的中医大师。

但是，我们要如果说把问题再往深一下，提一步，马上问题的性质就变了。谁说时方不能治病？时方也能治病。西医能治病吗？西医从整体来说，西医的疗效比中医还好，确实很快，但是现在我们慢慢地都弄清了，大量的社会上这些用抗生素治感冒，人家西医理论里边明文规定不能用抗生素治感冒。但是，社会上普遍地都用抗生素来治感冒，而且疗效还挺好。特别是一些体质稍微弱一点，而且刚用抗生素的人，有时候输上去，几个小时就见效。你说人家不治病吗？但是，你能往里边分析吗？再往里边分析，就是说这种疗效连现代医学自己都持否定态度，不可以！现在咱们国内的人出国以后，在国外感冒了以后要求输液，人家外国的医生都觉得很奇怪，抗生素不治感冒，你输液干嘛？那么细究起来，这里边问题多多，不是一个方面。

我在这儿，也说一个具体的事儿。咱们国内某某中医大师，国内一流的中医大师，说了一个医案，电视上报道的，说是治了一个疑难病，让病人吃了五年药。从一个生活不能自理的人，五年当中慢慢恢复，慢慢恢复，后来恢复到了基本上跟正常人一样。大家想想，这个五年，我们换一换角度说，上海的陈玉琴发明了敲胆经，他敲胆经不用药，一点药不用，他不会开方子，只开一个方子，就是青皮和陈皮各十克，就会开这么一个方子，他不会用药，就是敲胆经。三年敲好了吴青松他母亲的皮肤癌，一点药都不用。大家如果说比较一下就知道，什么概念？我记得前边和大家说过，我经手的一个肺癌，那个肺癌是绝对不会有任何掺假的，因为她到各级医院，一直到北京、天津、济南、临清，我们这儿离得近，都拍过片子，结论都是一致的，她是肺癌。为什么找到我看病呢？因为她瘤子长到大动脉上了，没有一个地方敢给她做手术，回到家以后，给她的结论是存活期还有半年，回到家等死来了。然后在我这儿，现在这个病人已经两年多了，她吃了多长时间的药？吃了八个月的药。今年她春节前后又有点着凉，又咳嗽，大概又来吃了不到两个月的药吧，现在老下地干活，六十多岁的一个老太太，年龄还不算很大，现在体格很好。所以说这里边，你要如果说不比较的话，怎么不能治病啊？能啊！

其实这儿，我们等于说澄清了另外一个问题。我们为什么要学经方？经方的疗效，你要是真正把经方学到家了，经方的疗效不是别的任何医学能相比的。不是说别的医学不能治病。

而且这里边还有一个问题，经方的医学理论，这一套理论如果说你要是真正弄通弄懂了，你整个人的世界观都会变。我前边跟大家交流的时候，好多东西，大家有这样的感觉。

那么在这儿，我们也说一个具体的。就是昨天晚上，中央十套《走近科学》节目播了一个什么啊？那个题目是《抗癌计划论》，他播了一个病人，患的是淋巴瘤。怎么通过靶向治疗，疗效不错。这个现代

医学的有些研究非常客观，对癌症的论述，很多地方非常值得我们借鉴，实际上，非常客观的。前边有一个基本论述，也就是癌症的概论，简单的一个概论。这个概论里边，它有一个主要的观点，就说癌症是一种什么性质的疾病？就是正常的细胞突变以后变成癌细胞了，无节制地疯狂地繁殖就形成了癌症。而且每一个正常人身上都有癌细胞，不单单是这样，就是一个正常人每天都有 3000 到 6000 个细胞，由正常细胞突变为癌细胞，换句话说每个人身上都有癌症。但是这叫有癌无症，说得非常客观。因为人体的抵抗力可以准确地把它识别出来，及时地把它消灭掉，或者说把它限制在一个非常低的水平上。我觉得这样说比较客观一些，大家听一听，说得非常的客观。只有通过现代医学科学手段才能得出这样的结论。但是再往下就不行了，跟经方理论一比较，不对了，它说得非常好。那么到这个时候，我们治病就出现两条路：一条路就是杀死癌细胞；另一条路就是让人恢复到常人的状态。常人什么状态？他自己的抵抗力可以准确地识别癌细胞，可以控制在正常的范围之内。那么大家想想，这不是一个很好的治疗癌症的途径吗？为什么不去走这一条途径，而是非得用一些有毒的化疗、放疗去杀死癌细胞，同时又伤害人体呢？因为什么呀？因为现代医学对提高人体的抵抗力的技术手段非常有限。你要是到医院里边，对医生说，我这段时间体质比较弱，抵抗力比较低，你能想办法让我提高一点吗？实际上他是一点办法都没有的。这在我们中医里边，任何一个中医都能办的事。是不是？这就出来了。你说现代医学好不好？能治病吗？能治病。谁说不能治病了？但是这么一比较，你就会发现问题，这就出现问题了。

经方医学和其他的医学都是这么一种关系。那么我们把这个问题把它说透了，西医治病它是受技术手段的限制的问题，它掌握最先进的技术，但是技术永远是不成熟的。哪一种技术到了成熟的阶段，也就到了生命的尽头了。就像我们现在的医生，医院里边医生最常说的

一句话，很客观的话，很多问题是解释不了的。为什么解释不了？技术手段不到家嘛。那么这个时候，受技术手段的限制，他没有能力去提高人体的抵抗力。但是他能找到癌细胞，慢慢地去找。我们现在不涉及商业利益的问题，咱不涉及这个问题，因为这不是技术问题。他对那个事儿没有能力，但是他可以冲着癌细胞，找一些可以杀死癌细胞的东西。这个过程当中，人体要倒霉了。倒霉就倒霉，那也没办法。现在常说的一句话，反正是为了你好。

那么咱们再换一个角度看呢，中医是怎么治啊？表面上看，中医很落后啊，从它的理论里边还不知道癌细胞是怎么回事呢？甚至不知道高血压是什么？那么中医治疗是对症下药。有的是办法改善人体状态。这在中医里边都是小儿科了，最基本的常识了。你用药可以，不用药，我还有不用药的办法。这一类的办法有的是。包括理疗方面的，办法有的是。

那么我们再比较一下中医里边呢，中医里边也还是可以再分析的。中医里边你再去看经方和时方，要如果说相比较的话，你再比较。说能治病吗？都能治病。但是程度一样吗？程度能一样吗？那差远了。咱不去说得太具体了。不用说得太远了，就说咱们现在，就说现在整体地看，为什么我们中医整体疗效都比不上西医啊？为什么呀？这就很清楚了。我为什么说这个呢？我就想说咱们在学习经方理论的时候，特别是对王叔和的条文，不是说他完全没有道理，我们应该客观地看。如果说他在方向上给人误导的话，他的不正确的面就大于合理的一面。其实说的经方学习上，也就是说，从历史上看，就是对经方理论的误导太厉害了。到现在，如果说大家有机会的话、有兴趣的话，你再去看看近代的人，也就是王叔和以后的人，凡是研究《伤寒》，研究经方理论的，不往《内经》理论上靠的人，真正的有成就的，就只有胡希恕一个人。所有的其他人都拼命地往《内经》理论上靠。这是我们需要澄清的问题。这是我想了好长时间，很不容易说明的。常

常遭人家问，你把这个事儿说得这么明确，泾渭分明，难道说人家一点正确的东西都没有吗？难道时方不能治病吗？这是一个很自然的事儿。但是，你要如果说再去看一看结果，看一看我们周围的现实，就会发现，我们必须得用一种恢复经方理论本来面目的态度来学习经方，不然的话，还是要走上那么一条，大家都走的一条弯路。

大阳病、发热而渴、不恶寒者、为温病、（6）

若发汗已、身灼热者、名风温、（6）

风温为病、脉阴阳俱浮、自汗出、身重、多眠睡、鼻息必鼾、语言难出、（6）

若被下者、小便不利、直视失溲、若被火者、微发黄色、剧则如惊痫、时瘵痼、若火熏之、一逆尚引日、再逆促命期、（6）

胡希恕：这个病形似太阳病，也头项强痛，脉浮，很像太阳病，但主要的是它渴。这个渴是内热的一种表现，像阳明病白虎汤证就渴呀，它里头有热。里热的这种病啊，它不恶寒，这是什么道理呢？它也身热，身上不是不热，根据我们刚才讲的太阳病，身上热，加大外边差距，他要恶寒的，这个是不恶寒。这里热是很强烈的，人身上的这个条件反射啊，这是巴甫洛夫弄得，这个我认为很好。

这种刺激过于兴奋，那一种刺激就被抑制。他是个实验，这个巴甫洛夫很有意思，他用那个狗呀，用很热的电线烫这个狗，这个狗当然叫唤了，甚至咬他，那时候喂它什么它也不吃，可是呢他每要见到这条狗就给它好吃的。过的日子多了，狗一见到他拿电线，它就淌哈喇子，它就老老实实的。后来都给烫破了，它也不动弹，直撂滚了。为什么呢？它这个食欲过于亢奋了，把烫的这种疼的刺激反倒抑制了。这也是的，这个里热啊刺激相当厉害，要不阳明病的人都说胡话，

谗语烦乱，它这个刺激相当强烈的，尤其对于大脑。所以这个恶寒他倒不恶寒了，他是光恶热了，就是恶热的这种刺激过于亢奋，而恶寒的刺激被抑制了，所以就不恶寒了。温病就是这样，发热而渴不恶寒者为温病，里热，这说的很清楚了。你看这个地方还这样，与上面的“中风，伤寒”的文法就不一样，那个“名为伤寒”、“名为中风”，这个是“为温病”。

那个中风、伤寒都是太阳病的一种证，这个是温病，是对着太阳病说的，太阳病才叫病，这个温病不是太阳病的一种证，它是对等的看法。这是另一种病，叫温病。所以他（伤寒论）的文章就是这样，你要细心读就能够知道了。那么既然是温病，就不能根据太阳病的方法来了。太阳病治疗是发汗，温病不属于太阳病就不能发汗了，里热是不能发汗的，这个千万要注意。

假若发汗的话，这个发汗最伤人津液。这个里头有热，就怕发汗，你越发汗，他越热，像我们这个壶在炉子上坐着似的，火蒸着它，你再一撤这水，这壶热的更快。这个温病就是如此的，它是热病，里头有热，不能发汗。假若发汗之后，“若发汗已”，就是发汗之后，假若这个你当了太阳病了，而误发其汗之后，那不是一般的热了，身灼热，身上干热干热的，灼热，像火烤的那样子，这就是由温病变成风温了。这个风温怎么起的，就是根据底下这个证候，我们头前不是有个太阳中风吗？发热汗出，他这个也汗出，也发热，但是他不恶风也不恶寒，他是热盛啊。类似中风的那种情况，这么一种温病，他的意思是这个意思，所以叫风温。

那么，它的证候是什么样的呢？底下就解释了，“风温为病，脉阴阳俱浮”。就是上下的脉全浮，这个浮呀，也主表也主热，这就主热。“自汗出”，那么这个身灼热自汗出，我们讲阳明病就有了，它这个热由里往外蒸的，里热往外出的这个热就是蒸蒸，身上热而汗出，它是这么一种汗出，不像头前那个中风证一样，他那个汗出的有限，

它并没透，所以肌肉还是不解。这个不是，它是由里往外出汗，他是热。

“身重”，这个身重也很重要，说明身体有湿，皮肤肌肉里头湿挺重的。这说明什么问题呀，虽然里头热，身上还这么大的湿，说明里面不实，这个在阳明病里头就有了。凡是阳明病的里热最伤人津液，热实到极点了，津液就枯燥了，所以大便也干了。水火这两个东西互相排斥的，火盛了，水就少了，水多了，火就要熄。所以在这个里热程度上看，身还重，里还不实。由于这个热往上涌，鼻息必鼾，出气呼吃呼吃的，有声。

“语言难出”，这都是热往上涌的反应。这就是说这个温病就是加重了，假若要是发汗，吴鞠通《温病条辨》还说用桂枝汤，这个用不得。温病里头有热用桂枝汤是绝对不行的，不但这个桂枝汤不能用，就是银翘散、桑菊饮也不可以用。这个咱们要注意了，要记得。这个病就是白虎汤，它里头热，不是表热，解表没用，越解表越坏。桂枝汤更不能用了，那是甘温的药。

上边隐伏这个身重，就告诉你辨证了，中医就这个东西，不辨证不行。“直视，失溲”，下后伤津液，吃泻药、发汗药，都伤人津液、伤血液。而且里头不实，身还重嘛，湿还盛嘛，你为什么给他吃泻药啊？一吃泻药，更伤津液了，小便没有了，小便不利，这就是津液丧失的太甚了。吃下药为什么也伤津液？下药这个东西就是把胃肠里头原来给消化吸收的东西都给催下去了，可不就是丧失津液了。所以下、发汗都是亡津液亡血液的。津液亡失多了，小便也就少了，同时眼睛也发直，眼睛失去血液的濡养，就发直。同时这个下药伤脏气，如果里头是热实的，像阳明病大便秘，下而不伤人的。里头不实，下的脏气虚了，不但小便不利，由于津虚，膀胱有点尿还憋不住，还就拉了，失溲，这个病就比上面那个风温就更重了。失溲者，就是肾功能失去收摄作用了。

若被火者就更不行了，它是温病、是热病。这是以火济火，如抱柴救火，这火烧的更厉害了。“微发黄色”，微，有点，所以说要被火呀，这个人顶轻了，这个人脸上身上都是黄的，这个黄不是发黄疸，就是微黄的样子，一点血色都没有。那么要是剧呢，剧就是厉害。“剧则如惊痫，时瘈瘲”，就是一阵一阵的发惊恐，时常的抽，身上的颜色就不只是发黄了。“若火熏之”，就是拿火烤过那个颜色，所谓黄褐色了，就是熏肉那个颜色。

“一逆尚引日”，就是指泻下和火攻，这个火攻是古人治病的方法了，有很多种火攻的方法，（比如）扎火针，再如把地用火烧得非常热，人躺到上头，也就是捂大汗，这也是火攻的一种。再有就是熨背，后背拿热东西敷，这都叫做火攻，这个火攻是必须大汗。“一逆”是指误下，人还能活些日子，“尚引日”，但是已经是很重了。“再逆”就是指火攻，活不了了，真像如火熏色那个样子，那就是促其命期了。那么这一段呢，有人就讲张仲景不讲治温病，这段很清楚。所以温病不能发汗，又不能吃泻药，更不能用火攻。火攻与吃凉药都是对待的看法了，温病能到这样子，就得清了，没别的办法了。可见这个温病只能用白虎汤，根据他这个条文，绝不能发汗，泻药也不行，他没有实，实可以。那么后世，你像陈修园他们主张，真正的温病实证，可以用大量的麦冬、生地配合白虎加大黄，这我实验过，非常好使，但是得实。什么实啊？人说胡话，大便干了，那么这种温病你也说不能下吗？那得该下就下，但是只是攻不行，你得用强壮滋阴解热的药，就是麦冬、生地这类药，相当好使，得大量的用，不用生地用人参温补行吗？

那么这个《伤寒论》里讲不讲温病呢？讲的。这一段在太阳病中提出来了，你不要把它当成太阳病来治疗，后来我们在阳明篇里就有了。阳明篇里讲“外证云何”呀，那就是指温病了。“身热汗出，不恶寒，反恶热”，那就是温病，就与这个一点不错嘛。那个用什么治，

就用白虎汤，渴呢就用白虎加人参。他讲的这个都对的，怎不讲温病啊。这个读书，你得前后看。但是太阳病里头没有温病，温病不属于太阳病。也有把中风，伤寒，温病放到太阳病里边，这就错了，根本不是太阳病，不是在表呀，所以特意拿出一节来，讲的是太阳病啊，恐怕医家也拿这个当太阳病来治，一治这就坏了，辨证主要的一点呢，就是“渴而不恶寒”，“不恶寒”就与提纲冲突了。前头说了，“太阳之为病，脉浮，头项强痛”，为了加重恶寒的语气，才搁了个“而恶寒”。那么这个不恶寒，就不是太阳病。那么所谓的提纲啊，是太阳病的起码证候啊，他必须具备这个条件，尤其这个恶寒。

李冠杰：第6条从《康平本》里边看，成分就比较复杂一些。在《康平本》里边，就分了四段。那么我们一段一段地来学习。这四段分别出自两个作者的手笔。我们在学习过程当中，会分别进行分析。

第一段：“太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病”。这一段是顶格排版的内容。就是说可能是《汤液经》的内容。这一段字面意思呢，我们把它这样理解比较好一些：还有一种近似于太阳病的疾病，表现为发热而渴，而且不恶寒，这样的我们称之为温病。

这里的“太阳病”，在经方理论里常用这样的叙述手法，这里的太阳病不是说他后边说的这个就是太阳病，因为后边有嘛，有“温病”嘛。这个“太阳病”的真实意思是什么呀？就是想说，它有某些太阳病的外观，貌似太阳病。一看就跟得了太阳病相似。比如说：他也可能有头疼啊，他也可能脉浮啊。但是这个太阳病它具体表现有跟太阳病不一样的地方。哪儿不一样呢？

这后边说了，“发热而渴”，这个发热啊，太阳病基本上都有。但是呢，它伴随着一个渴，也就是说，人不单单是体温高，而且他口渴。在这里这个口渴的机理是什么？这是人体有了内热，有内热以后，整个人体的内脏啊，处于一种过度的亢奋状态，在这种状态下，人体体内所有的循环都加快。所以说，会产生大量的热量。那么产生这些

大量的热量呢，它就要通过出汗也好，通过小便也好，它就要散发出去。所以说呢，耗费的这些水分就比较多，我们中医叫津液，耗费的津液多，里边很快就破坏了以前的平衡了。那么他就感觉到需要补充水分，人呢就有一种渴的感觉，这个渴是这么来的。当然还有别的渴，比如说五苓散的渴，跟这个渴机理上不一样。同样是渴，“渴欲饮水”，但是呢，它是不一样的，机理上不一样。

还有一个很重要的症状“不恶寒”，这个“不恶寒”本身，这也是古人论述问题非常高明的地方。大家说这个“不恶寒”还是一个症状吗？而且这个地方呢，也没有说他恶热，没说。要说恶热的话，这还算一个明显的症状。唉，感觉怕热嘛，不怕冷，怕热。这就是说“不恶寒”，这“不恶寒”不是一个证。那么怎么叫正常人呢？你恶寒了是特别怕冷，恶热呢相对地说是特别怕热。那么“不恶寒”，但是也没有说，没有不恶热。对不对？那么所以说呢，这个“不恶寒”呢，你看起来好像不是一个症状，但是它确实就是想说什么？这个用词非常微妙，因为他没有热到一定的程度的时候，他可能没有明显的恶热的那种感觉。特别是有太阳病，如果说发展成阳明病的时候，初得阳明病的时候，甚至初得的时候还有一点点恶寒呢，那么它总有一个过渡阶段。所以说，要如果说里热没有这么重的时候，它不一定恶热。但是呢它得有个前提条件，你不能恶寒。因它比较典型的一个症状是它跟太阳病不一样了。太阳病是老是怕冷，甚至有时候打寒战下来，盖二床被子，那种比较典型的。但是这个呢，他不恶寒，没有明显的恶寒的那种，这就跟太阳病区分开了。

另外呢，这儿还有一个问题，就是一个胡希恕解释：因为里热太盛了，里热的强度超出了，它对人体神经刺激啊，超出了那个就是，体表不是发热吗，超出了体表发热以后，跟外界的温差对人体的刺激，所以说就感觉不到有恶寒的那种感觉了。这是一个方面的因素。

还有另外方面的因素，那就是说我们应该这么去理解：表证的恶

寒呢，那是表证的一个特征，就是说那个时候很可能大部分的能量都用来恢复肌表的那个机能，所以说那个时候呢，肌表御寒的能力就是说相对地也比较弱，再加上体温高和外界的温差。但是这个温病就不是了，温病它里热，严格地说温病应该属里，这里边没有论述它的表证，没涉及到表证。所以说，这个地方它没有表证。这个时候虽然说体温高，但是，仍然是没有恶寒的这种感觉。

后边最后三个字“为温病”，这三个字，关键是我们要怎么看，这三个字实际非常重要。“为温病”，这里边包含着一个很重要的问题，你看前边太阳病的基本症状外观跟得了太阳病差不多。只是“不恶寒”了，有些口渴，整个疾病的性质就变了，它不再是太阳病了。那么从这儿，我们能看出经方理论对疾病的界定完全就是以症状为依据的，以人体得了疾病以后，症状反应为依据的。那么实际上，这里边这些症状，再加上这些症状有一定的，这应该叫可塑性，就是说这些症状有一定的不稳定性。你比如说太阳病，“太阳病，脉浮，头项强痛而恶寒”。这还是基本的，还有一些其他的，那么是不是每一个得太阳病的人，都同时反应出这些症状呢？常常不是。

那么大家再看看，这一个温病呢，恰恰就是在太阳病的基础上，又出现了一点新的症状，整个疾病就改变了。实际上从这儿，我们大家应该去体悟经方辨证能从这么纷繁杂乱的疾病反应症状里边，能总结出规律性的东西，这是一个很了不起的事。

那么这一段它本来的意思，我们应该这么去认识，就是说还有一种疾病反应，特别近似于太阳病的这么一种疾病，但是呢，同时表现有口渴和不恶寒的症状，那么这个疾病的性质，也就随之而发生了变化，我们把这样的疾病叫做温病。我们现在看这就是一种里热的病，有了里热了。

其实我们在临床辨证当中就应该特别地去注意这些东西，这很重要的。尽管说咱们学习才开始，真正要结合临床的话，就非常得重要。

跟大家说，今天早晨我自己服了一次药，半下午的时候服了一次药，因为今天晚上有活动嘛，我就把今天晚上应该服的药，提前服了。我服的什么药呢？理中汤合上黄连解毒丸（黄连、黄芩、黄柏和栀子）。这基本上是一个典型的温热药、一个典型的寒凉药。因为我这个肠胃也是个老毛病，基本上在最近几年，已经恢复得应该说很好了。老是觉得有一点点不太舒服，就仔细地去感觉。从大便上看，不太成形，然后呢，不愿吃凉东西，很明显的有里寒了。但是呢，小便黄，然后有时候睡觉的时候，明显入睡有一点慢。再加上像脉、舌，多少舌苔稍有一点点黄，还有一点热像。这就是一个寒热错杂，没有明显的症状。前边呢，我根据这一类的情况，前天的时候吃过四逆散，吃了以后，当时也觉得初吃下去稍好一点，第二次再吃就觉得不太对路，因为没有实证。所以说呢，换成这个药呢，就是说它寒热错杂，你就用寒热错杂的药，换了吃了以后就很舒服，那仅有一点点不舒服就没有了。就是说在临床当中，辨证应该是一个非常仔细的事，特别是一些比较复杂的一些老病，一些陈年的老病。

第二段：“若发汗已，身灼热者，名风温”。这一段在《康平本》里边是降一字格排版内容。

我们常说把它看成是张仲景写的，这事儿呢，大家去整体看这个条文，我们发现，实际上这是张仲景为《汤液经》加的一个解释。因为他下一条说的是“风温为病”。前边说了“温病”，后边马上又说一个“风温为病”。

那么“风温”是什么呢？这里张仲景实际上结合自己的临床经验。在当时看来，治病的过程当中误治的机会还是比较多，在社会上医生给人误治了，这种情况挺多。那么张仲景在临床当中总结了以后，然后就发现，《汤液经》这个条文里边后边说的风温病的这些症状，是因为温病经过误治以后，经过发汗了。本来温病是不可以发汗，那么发汗以后呢，就出现了诸多的变证。这里边张仲景加的这个条文，其

实我觉得咱没必要说是，就是看了张仲景的条文就歌颂个一塌糊涂，看了王叔和的条文就贬得一塌糊涂，也没必要那样。

但客观地看，他这个条文，他用自己在临床当中的体悟，给这个《汤液经》的内容做了一个说明。就是说什么样的东西、什么样的病是风温。但是，这里他等于说一箭双雕，有两层意思：一层意思呢，是承上启下，跟你说这个“风温”是怎么来的；另外一个呢，又说明了一个很重要的治疗原则，温病是不可以发汗，温病不能发汗。

其实大家去看一看，如果说你仔细，有时候你品一品这个条文，就是《康平本》里边那些顶格排版的那些条内容，就是重于说症状，少于论这些理。所以说呢，在这个地方，张仲景理解得比较准确，而且张仲景加的这些东西，能起到画龙点睛的作用。

那么这儿，直接把它翻成白话的话呢，就是：温病如果以发汗的方法治疗后，若出现身灼热的，就称之为风温。

这个“若发汗已”，实际上就是说发汗以后了。那么这个地方已经隐含了发汗本身就是误治的这么一层意思。

这个“身灼热”，就是体温很高了，用我们的土话说，就是摸了就烫手。

这个“名风温”，这里边也有另外一层意思，就是起这么一个名字叫做风温，跟风没有关系。大家要时刻注意这跟风没有关系。

那么第三段：“风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出”。这一段又是顶格排版的条文。

那么，我们把它翻译成今天的语言就是：风温病的表现为脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。

那么这儿的“风温为病”，有了张仲景前面的那个说明，咱们呢就比较好理解了。我们也可以就这么去说，温病发汗，用发汗的方法误治以后，可能就会出现，或者说大多数的情况下会出现下边这样的情况。那么这样的情况下出了很多变证。这里边就有一个问题了，为

什么会出现这样的变化呢？有一个很重要的原因就是，大量地发汗本身，能使人的体液丧失。这本来就是温病，温病本身就是处于一种亢奋状态，他的体液本身就处于一种缺失的状态下（口渴嘛）。那么在这个时候，你要再进一步地发汗，而且他又没有表证，这完全是误治了。那么这种误治以后，会进一步地加剧人体津液的丧失，人体津液丧失到这种程度，人就会出现一大堆新的变证。

这个“阴阳俱浮”的脉，就是整个的脉体都是呈现一个浮像。这个脉跟太阳病的脉还是一样，太阳病也是脉浮。但是，虽然说它跟太阳病的脉一样，但是它的机理却是不一样。这个时候，这种脉浮是怎么形成的？根本的原因就是人体的机能处在一种过度的亢奋状态，这亢奋的状态，会对人体有什么样的影响？就像咱们开车一样啊，这个汽车的怠速调得太高啊，你把车停在那个地方，它就哗哗的转速很高，转的将近两千转，那么，它耗油也多，产生的热量也大。人体就是处在这种的状态，他比正常人整个里边周转的都快。那么，就会产生的热量大，产生的热量过大。热量怎么来的？那就靠着心脏额外的供应更多的，就是说让血液循环得更快，循环的速度更快，循环得量更大，才能满足脏器亢奋的这种需要。那么在这种状态下，我们这个血管里的血相对地说就比较多，特别是在体表，它把水分送到体表来，用出汗的方式（这可不是驱除外界的病毒了）散热，要把这个热量散发出去。所以说呈现一种浮脉。

那么，“自汗出”就比较好理解了，这个“自汗出”就是要散热，里边太热了，本来就是一个里热的病，你再出了汗以后，你发汗了，发汗本身就有的因素了，发汗的本身也就是解表嘛，打开汗毛孔。那么，汗毛孔本来就有汗出了，有里热它就需要散热了，本来就有出汗的这种趋势了，再吃了发汗的药，那么，这个汗出就更明显了。但是，这个汗出呢，不是表虚的，也就是说你吃了解表药以后，你这个汗毛孔呈现一种打开的状态，它不是那种肌表的虚证，它没有那方面的因

素。另外一个就是人体体内它有过多的热量，需要用出汗的方式，把这个热量散发出去。里边又热又缺乏水分，你再发汗，又进一步地通过体表再去丧失一部分水分，而且这个时候里热就更重了，形成了一个恶性循环。里热更重，那么进一步地，它还想用出更多汗的方式，来进一步地散发里热，出现这种情况，把大量的体液都排斥到体表部分。

这个时候就会出现“身重”，这个“身重”就是人体主观感觉到身子发沉，不愿意动。那么，这个“身重”啊，从我们刚才对这种病理的分析啊就知道，人体的体液也是集中到体表部分。那么，集中到体表部分，这些体液实际上大部分是已经经过内脏，已经使用过的一些废水，它要作为汗液散发出来。散呢，一个是散体内的热量，再一个呢就是排除这些废水。所以说这些水分集中在体表，会影响体表组织的营养供应，就是说这个血液里边含得这些废水太多，新鲜水分、营养成分就不能及时地送到体表，所以说人就感觉到没有劲，再加上水分多，组织就相对来说比较沉重，整个就感觉到“身重”。

这个“多眠睡”，我们怎么去认识它？实际上，人得病这个时候就重了啊，人就昏昏沉沉的，老想睡觉，近似于一种昏迷的状态。它不是休克的那一种啊，我们也可以这么想。在这种情况下，他的大脑啊，实际上也会缺乏营养，再加上里边过多的热量，机能过于亢奋，也影响到一些精神方面，所以说他精神也不好。

这个“鼻息必鼾”，把它理解成什么？呼吸抽动，急促，这么一种情况。大家想想这种情况下，精神就开始受影响了，所以说我们可以想想，他恐怕是呼吸道这些组织里头松弛，再加上需要大量的新鲜的氧气呀，因为里边亢奋耗费的营养太多，呼吸呢，呼吸又粗，又快，再加上呼吸道里边的肌肉松弛，跟我们晚上打呼噜有点相似。但是，没那么重啊，主要是以呼吸道抽动、急促为主要特征。

“语言难出”，这就是一种神志不太清醒的这么一种状态，以至

于影响到他的语言功能。

那么，这一段论述的主要就是温病误汗以后会出现的一些变证，同时，这里边也包含了温病不可以发汗。然后呢，发汗以后，会出现这么多的对人体的影响及危害。

第四段：“若被下者，小便不利，直视失溲。若被火者，微发黄色，剧则如惊痫，时瘵疢，若火熏之。一逆尚引日，再逆促命期”。这一段呢，又是降一字格的条文。

从这个条文里边我们能看出啊，张仲景在临床当中没少碰到让别人误治过的，把温病当表证误治的这种案例。

它的字面意思呢，就是如果风温病，也就是说，本来是温病经过误治以后，经过发汗以后，成了风温，那么，如果是风温病，你再误施予下法的话，他将会出现小便不利，直视失溲的情况；如果误施予火疗的治疗方法呢，则可能会出现微发黄色，严重的则可能是如惊痫，时瘵疢；如果再以火熏的话，你这一再的错误的治疗，你错一次人可能还活几天，要如果说再连续的错误的治疗，就有可能出现医疗事故了。

条文里边这个“被下”，这里边就本身也是两层意思：首先一个就是温病不能下，这里说的温病不能下，那么风温病要如果说他已经发了汗了，你要是如果说再下，这个下法啊，泻下的方法，也能大量的丧失人体的津液，就有可能出现小便不利，就是人体的津液已经丧失得太严重了，以至于小便的量非常少，体内的水分就非常少了。还有可能引起，眼部肌肉的失养啊，这个眼球啊，“直视失溲”嘛，这个眼球就转动就不灵活，眼都直勾勾的。这儿的“失溲”，你看前边有“小便不利”，那么这个“失溲”就有了条件了：实际上这是一种小便量非常少，但是呢又失去了控制，也是因为体液丧失严重影响到了肾的机能了。

那要如果说“被火”呢，这个火疗啊，咱们现在用火疗的机会已

经非常少了。在古代的时候，就我觉得我小的时候啊，有时候在村里面还能见到有的老太太经常用一块布包着一块砖，一开始我看着都觉得奇怪，弄一块砖用布包着干吗？实际上是她每次做饭的时候啊，到最后剩的那些余火，她把那个砖放到里边，待上那么一段时间以后，那个砖是热的，然后把砖拿出来，用布包好了，她去烫烫她肢体疼痛的地方啊，烫烫肚子啊，就跟我们今天的暖水袋一样用。实际上那是一种比较简易的了。但是从那儿我们就能看出，其实古代的时候这种火疗啊，就是有很多方法了。从介绍上看，有的就是把地烧热了，然后让人呢躺到上面，上面再覆盖上东西，等等的吧。像火疗这种方法本身就是个以提高人体外环境的温度迫使发汗的一种方法。实际上，实质就是这么一种方法。所以说，用这样的方法来治疗风温也好，治疗温病也好，也都是误治。本身这人里边就热，那么你再进一步地提高外边环境的温度，那么这个时候，对人体的精神方面的影响就比较大。人都有点“惊痫”啊，就是说精神方面就像受了惊吓一样，这个“痫”就有点癫痫的那个意思了，他就像有一点一点抽。后边这个“时瘵”，就是时不时的就会出现一些抽搐的情况了。这就很严重了。

那么最后说像这种错误治疗你要使用一次，也许人还能活几天；要如果说一再地错误治疗那就很严重了。

整个这一条啊，我们应该在这里边学到什么呀？这一条他在强调什么啊？他在强调温病与太阳病的一个鉴别点，温病与太阳病不同。温病如果说你当太阳病治了，会出现一连串的不良后果。他主要强调的是这个意思。

但是这个地方，不是在讲温病怎么治疗，所以说后世呢，就说经方是不能治温病的。然后呢，又甚至发展出了温病派。

实际上，经方治疗温病也是疗效非常好的。像白虎汤、白虎加人参汤还有等等的，就是一些用寒凉药治的。

那么这里边，需要跟大家说的，就是说这个温病，为什么古人在

这里没有说它是阳明病？因为阳明病里边不仅仅是这种病，包括像承气汤证也是典型的阳明病。所以说要如果说把它说成阳明病那就不规范了，那就很容易让人混淆了。那么这儿所说的温病呢，实际上就是指白虎汤类方证，指的是那一类的疾病。也就是说还没有到了里实的程度。

那么条文里边啊，我们能看出来，像那个“身重”，“身重”里边就有这个意思啊。就是说他体内的津液，消化道里的津液还没有虚到那种使我们消化道里边的食物都干结到里边的那种程度。所以说，他还会出现那种“身重”啊，就是说体表还有停水停饮的这种情况。

那么主要矛盾是什么？温病的主要矛盾就是里热。但是基本上没有，最起码跟承气汤证比的话，没有里实，到不了里实的那个程度。这个事儿我觉得是这样啊，咱也不能把它理解成说是不是这个温病，也就是说白虎汤证，再进一步发展就会发展成大承气汤证啊，那也不一定。

有这样的医案，就是说这个人啊，已经接近于休克状态了，后来有医生看了以后，他四肢冰凉啊，甚至那个脉虽然说急数，但是也已经不现浮脉了。但是人眼是红的，扒开眼看一看眼是红的，然后还从其他的一些地方，就发现实际上这是因为里热太盛加上误治造成的。后来就给他白虎汤，这个人又慢慢恢复过来了。这是另外一种里热的病，但是在古人呢，就把它们都放在阳明病的范畴里边。

可是这儿呢，也有一个问题，就是说后边的白虎汤证，也没有明确地把它定义成温病。后边，在以后呢，再没有提过温病。在这个地方呢，只是用来强调一下：有的病和太阳病非常相似，但是，就是有一个口渴，不恶寒。这样的病，疾病的性质就变了，有了里热了，你不能光给它治表证，这是这一条的寓意。

那么至于说其他的，就是说像后边的阳明病里边的白虎汤、白虎加人参汤证，像这一类的方证，为什么不把它再另立一个温病？在《金

《要略》里边为什么也没有说温病？这个呢我们就已经无从考察了。但是现在呢从治疗上，应该就是像这种近似于太阳病又不恶寒、又口渴的这种就是白虎汤证，这是一个问题。

另外一个问题呢？大家要如果说有看过胡希恕讲座的，胡希恕在讲座里边提到了一个，就是说陈修园他们说，在白虎汤的基础上加上麦冬、生地、大黄治疗这种温病，或者说风温，治疗这一类的温病，疗效非常好。但是呢，我想是这样，大家得去看，分析这个药物，这等于说胡希恕给了我们一个方法，在白虎汤的基础上大量地去加麦冬、生地，适量地再加大黄。之所以加大黄，是因为已经有了里实了，大家不要把这个方子就认为，噢，温病，就是说我白虎汤加上这个就治温病了，千万不要这么去理解。之所以加大黄是因为有了里实了；之所以加生地和麦冬，这里边一个是有津液虚的问题，另外有一个人虚的问题，这一点很重要。人已经虚了，因为麦冬和生地都有补益作用。如果说人实，就是偏于实的，或者说人不虚的，你要是吃大量的这个药，常常反倒是胃里不舒服，这是需要跟大家说明的一点吧。

那么另外呢，就是咱们从这一条里应该去体悟一个什么？我们从这一条里边去品，我在前边已经简单地跟大家说了，那么是这样的，就再点一下就行了：我们去体悟经方辨证，古人从繁杂的症状群里边总结出了这么一整套的规律，我们学习的经方全是这些规律，那么我们今天学的时候，如果说，你想能把它把握的很好，就必须从病理这个层面上有所认识。比如这个条文，温病初得的时候，它有可能是由太阳病发展而来的，那么从太阳病发展而来的时候，一开始有一个是恶寒，后来到不恶寒，再进一步到恶热。那么在不恶寒的这个阶段，它跟太阳病特点相似，非常相似，脉也是浮的，也可能头疼，只是开始有一点口渴，不恶寒了。那么这个时候，你要把它错误地判断成太阳病，那么这里边还有一个过程的问题，如果说有时候也会夹杂着太阳病，夹杂着表证，像白虎加桂枝汤。不就是这一类的吗？

所以说这儿，实际临床当中辨证就是一个复杂的问题。那比较复杂的问题，如果说你要吃得比较透的话，这个问题其实并不是说不可以辨，而且还不难辨。

比如说，你面前有一个太阳病病人，那么太阳病病人，你要是简单问，你口渴吗？他说有一点想喝水。好，那你下边关注什么？下边就得关注他有没有里热的证据。像是不恶寒，小便是不是特别黄呀？舌苔是不是又厚又黄又干哪？脉是不是比较数呀？等等的吧，这都是。你要是知道病理了，你就可以从很多方面去找佐证。要如果说是死记硬背条文的话，当你找不到辨证的时候举棋不定，他到底有没有里热？实际上这都是我慢慢在临床当中自己这么走过来，凡是学经方，因为临床当中都会经过的这么一个阶段。解决的办法就是要深入的学习，从理论的层面上、从病理的层面上去认识经方的这一套辨证体系。

我们先讨论一个具体的病。我们看看在某些具体的病中，我们能够得到一些什么样的启示。因为它能说明一些问题，所以说我们把它当做能够帮助我们理解经方理论的一个实例吧，我们一块儿来认识一下。

今天说一个什么病呢？就是我们日常生活当中经常见到的脚气，这个脚气不是经方书里边说的那种“两腿无力”的那种脚气。就是我们长的一种皮肤病，脚气。这个病啊，一般地说，应该是不算是一个病，就是一般的算是一个皮肤病。但是这个病发病率很高，得这个病的人挺多的。那么，这个病为什么咱们要讨论这么一个不算病的病？一个是这个病啊，非常普遍，恐怕我们也许在座的人自己就长有这种病，然后呢，一般我们每个人的身边都能遇到这样的人；而且这个病呢，在社会上啊，应该说是知名度很高，差不多人都知道。对它的发病机理什么的，大家也都有所了解，对它都有一些常识。

那么我们呢，把这个病解剖开，我们把它剖析一下，看一看，从

不同的角度，我们看看能从中得到一些什么启示。首先说这个现代医学对这个脚气病是怎么认识的。现代医学认为啊，这个脚气病啊，就是真菌感染。正因为是基于这种认识，所以说呢，对于这种病的治疗就是杀菌。特别是现代医学啊，对这个病没有什么很好的办法，而且有效的药物很多，但是能够根治的药物几乎没有。就可以说没有吧，别说几乎没有了，就是说没有什么办法把这个病给根治了。从现代医学的角度来看呢，因为现代医学掌握着最先进的科学技术，所以说呢，它对真菌的认识比较具体，也比较深入。所以说，认为这个真菌是无孔不入的，它具有传播性，就是说它可以传染。所以说呢，现代医学就认为这个脚气是可以传染的。那么所以说，为了预防这种疾病，防止这种疾病的常识，凡是自己身边有人得了这种病或是自己得了这种病，或者是自己的家人得了这种病之后，那么平时要非常讲究，你比方说洗脚盆啊、洗脸的用具啊，包括一些像洗的那些袜子啊、内衣之类的都是跟别人的分开，跟正常人的分开。避免什么呢？避免这种病的传染。看起来呢，非常的科学，也非常周到，也非常具体，很有道理。但是，如果说你要换一下角度，那么我们现在啊，我们现在看中医怎么认识这种疾病。我想是这样，对这个病的解释，那个传统中医的解释啊，咱们知道也好，不知道也好，我们把它搁到一边。咱们就是说啊，从现代中医，也就是我们在与时俱进啊，随着科学技术的发展，科技啊，那个现代科学技术的一些观察手段，能够看到的一些东西、实实在在的东西。我们也接触很多中医理论，现在都介入了一些，借鉴了一些现代科学技术研究的成果。

咱们现代中医怎么认识这种疾病呢？这个病的根源是人的脚趾缝里边啊，起那个小水泡。实际上像这个呢，现代医学也是对这个有所研究的，它也认为这个小水泡呢，是这个病的一个很重要的一个特征。但是中医的认识呢，跟现代医学不一样的地方是什么呢？就是正是因为起这个小水泡，这才是造成这种疾病的真正的原因。因为这个

小水泡啊，它破了以后，就是说脚趾缝里边形成了什么样的环境呢？它既有水分，小水泡破了它不是有水分吗？然后呢，它又有温度，它又见不到光线，另外呢，它还有营养成分，就是这个小水泡里边含有少量的蛋白质，所以说它又有营养成分。好，这些条件就具备了真菌生长的良好的环境，所以说，那个真菌才在这个地方大量的繁殖，以至于造成对皮肤的伤害，发生病变。这个小水泡就是造成脚气的真正的原因。那么是什么引起脚气的？正常人怎么不起呢？人为什么起小水泡呢？我们放到后边再说。

那么这就有一个问题，中医的认识和现代医学的认识，就是形成一个最基础的方面是一样的，这一点大家都同意，就是说是真菌感染。而且造成真菌感染以后，因为认识问题的角度不一样，所以说呢，对待的办法也不一样。你像现代医学，它本身就是对抗性的医学，所以说呢它要杀菌。但是，我们再从治疗结果上看，实际杀菌呢，常常是这个病，几十年不愈，实际上是治不好的。为什么呢？你看因为杀菌啊，这个杀菌按现代医学，放在现代医学的治疗手段里边，这是一盘小菜，完全能治疗的，随便拿点什么杀菌的药都把菌杀了。但是它治不了的原因是什么呢？你今天把菌杀了，第二天或者说第三天，你的药效没有了，它又有破裂的小泡，因为你解决不了起小泡的原因，解决不了起小泡的原因，所以说又开始起小泡。小泡破裂了，又形成了那样的环境，这个时候药早就没有作用了，过了它的有效期了，所以说细菌又要繁殖。实际这个真菌是无孔不入的，你防是防不住的。

那么这里边，带出另一个问题。它是真的传染吗？这是一个很重要的问题。它真传染吗？事实上我们可以想像啊，很多疾病都是这样：实际上每个人的脚趾缝里都有大量的这样的真菌，但是不起小泡的人，它没有水分，没有养份，它就形不成真菌繁殖的这种条件。没有这个条件，它不得以繁殖，它在那儿只能维持在很低的水平上，或者说有一些自然死掉以后，又新进来一些，它总是在很低的水平上，对

人体丝毫没有影响。但是一旦起了小泡，条件足够了，它就开始繁殖了，那么这就成了问题了。

那么这个病到底是传染还是不传染？道理上说，是传染的。你要按现代医学说，它就是传染的，真菌那是无孔不入的，它怎么能不传染呢？只要是具备条件它肯定传染。可是从咱们临床实践上说，我敢说这句话：它实际上是不传染的。你只要是有了条件，你就是不接触有这种病源的人，你一样会得。那谁传给你了？实际上你脚上本来就有，能怨别人传染吗？这是其一。

另外，如果说你脚上不起小泡的话，那么，你就是整天跟有这种病的人在一起，它也不传染。这个事儿啊，我们现在身边这样的病人为数很多。就是夫妻两个人，一个得脚气多少年了，但是另一个始终没有。那么大家可能会说了，因为他们有这方面的常识，然后他们防得比较好，预防得比较好，什么东西分得都很清。那么大家想一想，当其中一个人初得这个病的时候，甚至他自己还没有发觉的时候，脚气总不是今天还没有脚气，第二天马上就脚气泛滥了，整个脚都发炎了。不至于到那种程度吧？它总有一个发病的过程。当他初发病的时候，他还不知道是脚气的时候，那个时候你说夫妻之间怎么计较？夫妻之间怎么去防备？当他不知道的时候呢？就是说你再有这方面的常识，卫生条件再好，你也不知道去防备这个。那为什么另一个人没有传染上？所以说，从这个角度我们再来看，这个脚气传染是有一定条件的；你也不能说它不传染。但是你脚上不起那种小水泡的话，对你来说，实际上就是不传染。

那么，我们现在为什么要讨论这么一个疾病呢？因为这个疾病我们很容易说得很明白。实际上现代医学那个所谓脚气的传染，相当大的一部分程度啊，就是一个虚的。我们经常说中医理论里边有很多虚的、假的、错的、偏的，大家看看现代医学里边是不是也有这种东西。更为严重的问题是什么？不仅仅是脚气这一个病，很多很多病都是这

样子。

你看去年德国发生的那个腹泻，差不多是全世界的医学工作者都去研究，都在找它的病原，结果到最后，没有找到真正的病原。你去找什么病原呢？它真的是从一个点上传染开的吗？

那么我们再推而广之，大家想想，不管多么严重的传染疾病，比如说甲流，非典，这个病在爆发的时候，是不是所有的人都得了？要是如果那样的话，那不是历史上任何一次瘟疫都会造成灭绝人类吗？那根本就不可能的。所以说这个问题啊，总是应该两个方面的去看问题。那么我们再具体地反过来再去看，因为我们说到了脚气，那么我们再看，脚气应该怎么治呢？你看啊，要如果说按照传统中医思维方式的话，有这么一种说法，说脚啊，胃经走脚趾头，所以说呢，认为脚气呢，跟胃肠的关系比较密切，或者说就是胃的问题，就是脾胃的问题。然后呢，当然就按照这种思路去治。但是，今天我们学经方，因为我们在座的有很多人，都有深厚的经方的底子。那么经方对这样的病，怎么治啊？经方是讲究辨证施治，那得辨证。你有什么样的证，我就给你对什么样的方子。等你的证消失了，你脚上的小泡就不起了。那么大家说：会不会是这样啊？

我倒是没有脚气。但是前好多年的时候啊，自己身体也不是多好，慢慢在调理的过程当中，其中有一段时间，因为我那时候有那么一个特殊的机会，就接触了一些化学药品。因为很意外，在自己看不到的情况下，那当时穿的是个布底的鞋，那些化学药品都渗到布鞋里边去了，结果闹得脚上起了一些大泡，那是大泡那不是小泡了。从那以后啊，每年特别是到了夏季，都明显地起。结果后来，到了大概十来年的时间，就没全好过，有的时候这一年，不明显，就不太在意了。说几乎每年，季节也不是特别固定，每年都有。都会起一些挺大的泡。大的就跟大拇指那么大，小的呢也要像小拇指头那么大的大小。然后那些泡起来以后只要是它不破呢，几天以后里边水分慢慢被吸收了，

它就会掉一层皮。但是到了后来，慢慢地，我自己一开始不用药，用一些理疗的办法来调理身体，身体逐渐得好。好一点以后呢，后来用药，就是用经方来调理自己的身体。吃来吃去，就明显地看到起泡的时间变短，频率变低，到现在说吧，就非常少了，起的就非常少。所以这就是说，你对了症，人体没有病，它内脏没有病，这种小泡也就不起了。不起了以后，这种小泡自然就好了。

那么我们今天为什么要讲这么一个问题？像这个问题啊，我在这跟大家讨论这么一个事儿，希望大家能够顺着这样的思路啊，往里想，大家往里想。现代医学也好，包括传统中医也好，很多的医学啊，在对疾病认识上都有类似的问题。

那么是什么原因，会形成这么样一种局面呢？大家仔细想一想，我们刚才讨论的问题，问题的症结在什么地方？实际上啊，问题的症结要说起来啊，非常简单。是什么？就是片面。所有这些问题都出在一个片面上。片面地强调他所知道的某一个侧面。在这个事上啊，现代医学是最典型的。因为它还不是这一个病。几乎任何疾病，小到感冒大到癌症，现代医学普遍存在这么一个问题。凭着一个什么呀？咱比如以感冒为例啊，我跟大家，恐怕我们整个这个太阳篇里边，就是说整个我们学经方的过程当中，这个感冒我会在不断地跟大家讨论这个问题。因为这个病啊太普遍了，而且又非常有代表性。

那么咱就说感冒吧。感冒呢，现代医学研究得很清楚，就是感冒病毒在人体防疫能力，就是说人体抵抗力弱的时候进入人体细胞了。它这一点看得非常的清楚，也非常对。对不对啊？对，也非常对。那么为什么比如说一家人，比如说夫妻，夫妻两个人，得流感的时候一个人得了，另一个人没有得，为什么呀？这就跟那个脚气又不一样了。脚气还是真菌感染哪，都是在皮肤上。那个好像还形像一点。像这个东西，那你怎么去具体解释这个问题？不得流感的那个人，为什么那个感冒病毒就通过他的肌肤进不去呢？而且他两口子还在一个床上

睡觉？关于这个问题，你看现代医学扔给你这么一个结论。但是，这个问题它想过没有啊，自然也想过。但是，它却不知道夫妻之间，一个得流感另一个不得，这个不得的和得流感的两个人，它只是笼统的知道了免疫力一个强一个弱。

那么免疫力强的和弱的有什么区别？怎么能想办法把这个免疫力弱的，能够让他改变得跟这个免疫力强的状态一样？对这样的问题，现代医学现在认识上非常肤浅，那么办法上几乎是没有。这就形成一种什么局面呢？形成了就说感冒，它知道了是病毒进入细胞了，所以说，按着它的指导思想和它目前认识的水平来解决这问题的话，那就只能是杀死病毒。但是杀死病毒，它杀不死，就像到目前为止全人类也没找到能够可以杀死进入细胞的这个病毒的那种有效药物。找不到这种药物。你要想杀死那个病毒，细胞必须一同杀死，那人也就完了。所以说，这就没有办法。现代医学治感冒就是缓解感冒症状，你发烧了我给用点退烧药，你要是流鼻涕打喷嚏，那就我给你吃消炎药，让你鼻粘膜发炎的程度减轻一点。就是人家说得也很客观，就是缓解感冒症状。那么问题的症结在哪儿呢？问题的症结就在于现代医学只是了解到了这个感冒病的一个方面，跟脚气是一样的性质啊。几乎其他所有的病都有这方面性质的问题。它只了解到了，现在只能研究到这个感冒病毒进入细胞。那么，人体为什么这个防疫能力差了，致使感冒病毒有机会进来呢？几乎一无所知，只是知道人体肯定是抵抗力弱了。那么怎么弱的，哪些地方弱了？怎么能想办法把它强化起来？一点这种概念都没有。那么我们现在还不说现代医学的商业这一部分，商业利益这部分咱们不去说。就说它现在从技术水平这个层面上，就解决不了这个问题。不但是解决不了，而且是认识不到，没有能力去认识到。认识不到不要紧哪，你可以虚心地看看别人怎么治的？但是，它就用它这个半拉子的认识就去治病、医疗。既然就是没有办法，也要勉强弄些办法来缓解感冒症状。

这说起来就有点可笑了。你看现在啊，就是电视上连着播了好几次了，这些科学家啊，宁肯去研究那些个动物吃了有毒的东西以后，它们动物怎么去有的吃土解毒、有的吃木炭解毒，去研究这些东西。他就说动物也是非常高明的，它们自己就会治疗自己的疾病。但是为什么？你们就不去想想中国，实际上啊，西方国家的那个传统医学也是用天然药物来治病。那个时候没有化学药物啊，他们也是用天然药物来治病。只是他们的医学，那个传统医学没有形成，没有形成像咱们中医这么完整、这么庞大的一套理论体系。所以说呢，它很快就一败涂地了，就有了现代医学以后，就都完全被淘汰了。我们从一些老电影上，大家看那个叫《虎口脱险》那个法国电影啊，他们的那个嬷嬷看病的时候，不也是看舌苔，也是看眼睛吗？其实就跟咱们传统医学是一样的，都有这么一个经历。但是他们现在去研究动物是如何用天然药物来治病的。那么你们的祖先早就知道，只是你们放弃了而已。为什么不再去研究呢？我们不能不说这里边有个商业利益的问题。那个呢，就不是我们讨论的问题。

但是我们就说啊，这个问题的症结在哪儿？为什么会出现这样的一种局面呢？就是因为对问题认识的片面、肤浅。把片面的东西当成全面的東西，肤浅的还没有认识透的东西当做最后的结论。大家想想是不是这么一个问题？

那么这里啊，再跟大家说得稍微远一点。在我们人类的科学历史上，发展到今天，可能是还没有哪一门科学像医学这样啊，有着一个很特殊的属性。它有什么特殊属性啊？我在这儿跟大家，就等于说跟大家打一打学经方的气。这个医学里边，大家是不是注意到这一点，医学里边有一个很重要的特征。什么样的特征？跟其他科学不同的，咱们打个比方，比如说我们现在人类发射人造卫星，造空间站。那么，空间站那个架构在太空弄好了后，每年都会几次地往空间站上就发一些建站需要的东西，站场维护什么的，有发一些东西吧。那么发这些

东西，每次当然我们现在用火箭往外发，总希望这一次发的东西越多越好。我们现在做一个假设啊，比如说现在我们人类有能力一次最多只能往太空发射 16 吨的东西，咱们假设说啊。那么要如果说你想让它发射 30 吨的东西，好，没有关系，这种愿望没有关系，等着吧，你等着吧，等过三五年以后，也许三十年五十年以后，也许三五百年以后，它可能随着科学技术的进步，它可能发射嘛。那么你现在的这种愿望，你这种需求，只能是作为一种愿望，你得等着。在技术达到之前，无能为力。要么你就分两次吧。它一次只能发 16 吨，你想发 30 吨，那分两次吧，就只能这样。咱们可以等，可以等的。很多东西都像这样。比如说电脑，那么电脑上面那个 CPU 的主频从几十兆赫发展到几百兆赫、几千兆赫，然后现在到了几个 G。它的主频就说运算速度，到了几个 G，一直到了接近 4 个 G 的时候，发现按照现在的技术水平，再想提高它的主频办不到了，提高不了了。那么后来就想了别的办法吧，双核的、四核的、八核的，就说把好几个 CPU 绑到一块可以提高运算速度，等于说是一个人要举起来的東西有限了，像举重运动员一样，让他再练，就是（最多）能举 256 公斤，好，咱两个人举，就那个意思。你要是想突破 4 个 G，除非个别的做实验的除外，商品化的是个很困难的事。但是理论上能达到，肯定能突破。什么时候能突破？等着吧！是不是？

但是医学不行，医学的对像不是那个东西，医学的目的是要治病，在了解疾病、了解人体、了解环境等等这些问题，最终的目的是要治病。这个得病，跟你的技术可没关系，就是说技术一点没有，他该得什么病还是得什么病。所以说这就出现了一个问题，咱现在如果说站在中医的角度来看现代医学的话，现代医学可以说，没有对哪一个疾病，完全都认识透了。咱们刚才说了一个感冒，它对病毒侵入人体是了解得很清晰了。那么人体为什么允许病毒进来，别的人为什么进不来，它就知道了，还有很大一块缺陷，还有很大的一个方面压根不

知道。那么其他的病不也这样吗？肝炎不也这样吗？肝炎病毒为什么在人体内繁殖得超量，肯定还有人体限制它的能力不足了。那么不足在哪儿？又知道了。但是要是从这个角度说，现代医学还真得了不起，就是说在还没有认识透，对哪一个疾病也没有完全认识透的情况下，能够找到治疗方法，所以从这个角度看，现代医学从某种角度看也是经验。就说它对这个疾病了解到这些，再往下了解，技术达不到了，它就去试啊，用好多化学的东西反复地去试啊。从理论上推导，这个东西可能对这种病毒有作用，试一试嘛，一试，好，确实有杀灭作用，然后再在人体上试。临床试验结果行了，比如咱们的抗生素什么的，不都这么来的吗？这也是经验啊。

但问题是，他们的指导思想是要把这个东西全部搞清了以后，他才有好的治疗方法。但是什么时候搞清呢？那就知道了。

那么咱们现在反过头来再来看看咱们中医，传统医学，特别是经方医学。你看咱们中医里边，咱们在一块儿讨论时间长了以后，就习惯用这种方式讨论问题，把经方医学和传统中医分开。大家看看经方医学给的是什么？经方医学给我们就是结果，结果！我能把 30 吨的东西弄到太空去，至于说为什么能弄上去？不知道，我给你说这个办法，你就用什么样的火箭，加上多少东西，哪个时候你用，天气什么样的时候能把它发出去。至于说为什么？不知道。也可以不知道，完全可以，它能解决问题嘛。你看咱们现在，很多。

说到这儿，我给大家说一个小事儿。前两天，我自己的外甥来我这儿，他看我正在核对《金匱要略》，他说：“你整天弄这个东西”？后来就聊起来了，他就想了解。我就把整个这个《伤寒论》的成熟过程像故事一样讲给他听，他听了听，觉得挺有意思。然后说：“给我看看吧，我这个小腿肚子痉挛，到医院去看，医院里边说，（那医生大概就这么告诉他的，）是‘不安腿综合征’，也叫‘不宁腿综合征’，没有办法！晚上挛得我睡不着觉，白天在办公室里坐着也挛得心乱，

心里边觉着很不舒服，这是什么原因呢”？我看他是一半想治病，一半是想听听中医到底怎么看这个事儿。我就告诉他说：“你的肌肉组织里边缺少某种营养，中医呢有药物可以改善你机体合成这种营养的机能，所以说我的药下去就能管用”。他觉得很惊奇，虽然说得很笼统，至少有个希望啊，医院里边还说没有办法呢。后来，他说：“你就给我弄点药吧”。我就给他芍药甘草汤，拿走了以后，他说：“这药苦吗”？我说：“这药挺甜的”。他就拿走，今天打电话给我说，我让他吃了四次，每次吃多少呢？就是我那 10 克大膏盒，芍药甘草汤比重大一点，大概不到 5 克，4 克多一点，吃了四次，就 16 克不到 20 克的样子。吃了两天，症状完全消失了，一点症状都没有了。他就问我：“我是不是还需要吃啊”？我就告诉他，因为是自己的亲戚（要是病人的话，我会建议他再服两天），我就说，你要是症状没有了的话，你就不要吃了，这个药如果说吃的时间稍长些的话，会影响你的小便不好，严重的时候可能会出现轻度的水肿。他说：“哦，那我不吃了，我放着这个药，我什么时候觉得有点不舒服，再吃”。

这就是一个非常典型的例子，现代医学对它有认识吗？有，但是认识得浅，也没有什么好的办法。但是我们传统中医，特别是经方医学，你说对它的认识，应该说更浅。但是我们会治，你看这个芍药甘草汤。关键是你对经方的理解怎么样？我是这么说，经方每一个方子，都像祖传秘方，关键是你对这每一个方子的理解好与不好。你像芍药甘草汤，它治抽筋啊、某些腹痛啊、包括打嗝，我也用它试过。打嗝是什么？现代医学研究认为不是膈肌痉挛吗？芍药甘草汤不就是治肌肉痉挛吗？大家可以试试。当然要如果说气逆得厉害的话，我觉得如果说有胃虚这一方面（的问题）的话，恐怕是旋覆代赭汤合上芍药甘草汤的话，可能效果会好一些。这不都是现代医学没有办法的病？咱们经方医学治起来，很轻松。关键是你了解得多少，不能再接着这么个讨论法了，就说这儿大家应该就觉得很清楚了，就说，对问题的

看法，有的时候你要是了解得不全的话，必须得承认自己的不足，你得实事求是。

所以说在这一点上，咱们经方医学应该是人类医学的一个巅峰。在张仲景那个时代，两千多年以前，就达到那个水平了，到现在依然难以突破它，这是非常了不起的。

病有发热恶寒者、发于阳也、无热恶寒者、发于阴也、发于阳者、七日愈、发于阴者、六日愈、以阳数七、阴数六故也、（7）

胡希恕：这一段也很重要，它讲太阳病啊。太阳病是表证，表证里头还有个少阴病呢。那么差别在哪呢？少阴病偏虚偏寒呐，所以一开始就病有发热恶寒者，那就指太阳病，太阳病是发热恶寒呀。没有热，一味是恶寒，那不是太阳病是少阴病了。就是说疾病的一开始有这么两类表证，有发热恶寒的，是发于太阳病；无热恶寒的发于少阴病。发于阳者七日愈，发于阴者六日愈，这是个约略之词。

真正的伤寒病啊，我也得过。在我小的时候我们家一家子，六七天的时候是个要紧的关头，病好不好在这个时候很厉害，老太太都知道，这几天是憋汗的时候，好大约在这个时候，不好这个时候也减轻，那么在六七天的时候减轻这个病就没问题了。那么这个书呢，也是约略之词。那么至于下面他说的“以阳数七，阴数六故也”，这是一种附会之言。古人有拿这十个数，一二三四五，这几个谓之生数了；六七八九十，叫成数，这是五行学说。你们排一排，一二三四五在上头，六七八九十在底下，一对六，二对七，不就这样子嘛。这个“一”呀是奇数，属于乾，乾坤的乾，就是天。偶数属于阴，属于地。他说天一生水，“一嘛”，属于天了，阳嘛，天一生水。你看看对应的是六，地六成之，这六是地呀，总得天地交媾万物生成啊，他是这么看的。他说天生则地成之，地生则天成之。数一摆就看出来了，“天一生水，

地六成之”。那个“二”，又是地了。“地二生火”，你看二底下是七，就是天了，天七成之。你看三又该轮到天了，“天三生木”，底下呢又该是地了，八，地八成之。“三”过去不就是“四”了嘛，“四”又是地了。“地四生金”，底下是九，九是天，“天九成之”。到五又是天了，“天五生土，地十成之”。他这个五行啊，是瞎造的，这么捣出来的。

那么阳数七，阴数六啊，就是根据这个，这是瞎说，所以我向来不讲这个东西。这就是五行的生成，十个数字。这个没什么意思，但是头前的那几句话，“病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。发于阳者七日愈，发于阴者六日愈”，这是一种约略之词，不关乎五行生成的关系。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边，是降两字格排版的条文。从知道的史料上看，我们一般认为，它就是出自王叔和的手笔。

这个条文里边，《康平本》和《宋本》有两个字的差别。看“发于阳者，七日愈；发于阴者，六日愈”，这是《康平本》上的文字。那么《宋本》呢，是“发于阳，七日愈；发于阴，六日愈”。这两个字的差别还是挺有意思的。我们单纯从文字上看，这两个字的差别不是偶然的，这绝对不是抄写的过程当中抄错的，这不是。那么，这有可能是王叔和二次整理的时候，感觉（因为这个文字是王叔和自己写的，他改的可能性是比较大的）到没有这个“者”字更能代表他的意思，所以把“者”字去了。就是《康平本》那个版式在第二次整理的时候，他就把“者”字去了，《宋本》里边没有这两个“者”字了。

那么，我们看看条文是个什么意思？用我们今天的话说呢，这个条文应该这么理解：人体患病以后，表现为发热恶寒的，属于阳性病；表现为无热恶寒的，属于阴性病。凡阳性病一般七天可痊愈，那么阴性病呢，六天可痊愈。因为“七”在易学中，是阳性数，“六”在易学中，是阴性数。就因为这个缘故。

那么我们对古人的东西都应该客观地看，先看看这个条文里边合理的一些因素：首先一个，阳性表证以发热恶寒最多见，这是一种常见的现象。那么，阴性表证呢，相对地说，发热的机会就没有阳性表证多，因为这是太阳篇嘛，很自然的侧重于阳性病，虽然条文里说的是病，没有指的是太阳病，但是主要指的就是太阳病了。因为这里涉及到阴性病，我们就把它作为阴性的表证。那么阴性表证发热的机会，相对说就没有阳性表证发热的机会多。这也是一个客观的事实。

还有一个“六”、“七”天，病痊愈的说法，我们现在讨论的是条文合理的一部分，就说六七天这个时候，人体得病以后，现代医学也证明了在六七天的时候，往往是疾病发展变化一个很重要的关口，或是发展成为新的疾病，或是病情减轻甚至自愈了。这也就是说，现代医学把它称之为人体疾病的一个自然周期，有这么一个周期。我们可以想像，就说古人也是在临床当中，发现人患了病以后，常常六七天的时候，有一个周期。这儿呢，恐怕很大的一个方面就是指的这一类的东西。如果我们把它看作合理的一面的话，就应该这么去看他说的这一类的东西。

还有一个，我们应该站在多理解古人的角度，虽然这个地方说了个六七天，不管阴性病也好，还是阳性病也好，反正是六七天这个时候，六七天痊愈。但是我们能够想像到，不管王叔和是什么样的水平？既然是能够整理经方这样的书，他必有一些从知识面上也好，从智商上也好，应该是有他的一些特点，有他的长处。所以说，也不会是所有的病，凡是阳性病都能七天愈，凡是阴性病到六天自然就好了。如果那样的话，下边他的潜台词就成了什么？所有的病都不要治了，只要是熬到六天、七天自然就会好了。这就很容易就看出来王叔和本身也不是这个意思。那么他为什么说这个呢？他就是想引出下边的内容。

另外一个就是最后，一个阳性数，一个阴性数的问题，“阳数七，

阴数六”。那么这个说法呢，胡希恕已经解释了。如果大家对这个有兴趣的话，你可以去看一看，在网上搜一下河图洛书，搜出来看一看对它的说明。你就会发现，那真是一个了不起的东西。也可以说在当时来说，算是一项发明。但是它说透了，它的实质跟那个像八卦那一类的、周易那东西都是相通的。它的实质是什么？它的实质还是研究的数字之间的逻辑规律，一些逻辑关系的规律。它实际上是数字的规律。其实中国古人也看到了这一点，就是说事物之间存在着普遍的联系，数字有这样的规律，事物之间也常常跟那个规律有些相似的地方。那么他就一相情愿的，把这些规律呢，反复地推演，推演得非常周密。然后呢，再把它套上自然，我们身边的自然事物当中的一些典型的東西。你像八卦不就是这样吗？可是这个过程当中有很多并不是特别得合适，要如果说特别合适的话，那就了不起了。所以说后来又出现了先天八卦、后天八卦。实际上这些东西，这就是说那个时候，如果说我们说倒退几千年以前的话，是很先进的东西。它确实在研究事物规律方面是一个非常有意义的探索。但是到今天，实践也证明了事物有它普遍的规律。但是更重要的是事物都有它内在的、自己的特有的规律。你看大家想想我们现在，中医里边现在还在每天都能接触到的，像传统中医解释的那个阴阳，像五行、像这个周易的八卦，像这些东西，包括我们现在好多人每天几乎都要说的像“天人合一”。咱们就说“天人合一”吧，天人合一说的是什麼？这个它比数字更进了一步，它不是用的数的规律，而用的是自然界事物之间和人体之间的某些联系、共性，它就说“天人合一”。

但是你现在要是客观地想一想，这个“天人合一”这种说法有道理吗？很有道理。因为事物之间都有一个普遍的联系。所以说呢，你像这个人身上有节律变化，天呢也会有一些节律变化，这都是。其实我在这说一句，咱不去过多地讨论，一句话说到底吧，与其那么认识，告诉大家：人和其他动物的那个关系，比人和天的那个关系要近得多。

最起码，就比如说吧，人和牛相比的话，最起码还都有五脏六腑呢；人和猴子相比的话，相近的地方就更多了，那个遗传基因上百分之九十九都是一样的。如果说站在经方医学的角度说，你“天人合一”你是桂枝汤证，桂枝汤可以治你的病；你天人合一你是桂枝汤证，桂枝汤也能治你的病。跟天有什么关系啊？人生活在自然的环境里，人为了适应自然环境他会有千丝万缕的联系，但是那些，毕竟是离了我们人体本身还要远一些。而且那些东西真正要研究透了，就说天人合一吧，天人合一，天下雨你有办法吗？天打雷你有办法吗？那人得了病咱还有办法治。

但是我们客观地说，就是说给王叔和争点儿理吧，他自是有他一定的合理性。所以说呢，我们也不能说一看到是王叔和写的条文就一棍子打死，也没必要。但是这个条文糟粕多于精华，那么我们应该客观地去认识这个条文，怎么客观地认识呢？咱们再看看它的不足的一个方面。

我们在实际临床当中，在经方理论里边，这个阳性证也未必是全都发热，这不是说了嘛：“发热恶寒者，发于阳也”。这个阳性病未必全都发热，实际上条文里边就有，那个麻黄汤证，就是这个表实证第二条不就有吗：“或已发热，或未发热”。什么意思？还有不发热的情况。实际临床当中真正表证不发热的，也不是说特别罕见，也有，有的是。

再一个就是阴性证，阴性证在经方理论里边，阴性证发热的也很多。你比如说麻黄附子细辛汤证、桂枝加附子汤证都有可能发热，当然它也有可能不发热。在条文里边就有，像麻黄附子细辛汤和这个麻黄附子甘草汤都可能存在发热的情况。所以说王叔和的这种说法就失于片面，片面就要出问题的。咱们前边为什么讲了那么多，就是为了我们更好地去理解这些东西。

还有一个就是六日愈，七日愈的问题。虽然说这个人体有这个病

理的周期性，但是，没有必然会痊愈的这种规律，而且真正自愈的，真要是说得病得了六、七天，能够自愈的，不是说很多，当然，自愈了那就没必要治疗了。如果自愈不了，到六、七天的时候对我们治疗会有什么影响吗？大家不管是在经方理论里边，回忆一下有没有这种条文；再一个就是看看临床当中有没有这样的东西。是不是吃药吃到六天，哎，别吃了，到好的时候了。有这么情况吗？没有。他好不了你还得吃。所以说，在临床当中也得不到验证。

另外一个就是这个“阳数七、阴数六”的问题。像刚才我们已经说了，这一类的东西你把它叫作玄学也好，叫作什么也好，它自有它自己存在的价值，但是不要用它来指导医学。实践证明用这些东西来指导医学的话，最终的结局就是误导，就是毁了医学。

那么，直到现在我们身边还有很多很多这样的情况。到什么程度呢？你看有人写论文，可以说，都是基于这种玄学的理论，都是从周易这个基础上来研究。他们也研究经方，主要的还是研究经方，与其说研究经方，不如说是在毁灭经方。

到最后发展成什么？他可以把疾病，把一个人弄得，把病人弄到床上，然后他认为他是一个热性病，然后他就把病人身边放一个冰箱，然后他用一些咒语什么的，可以把病人的病可以转移到冰箱上去，或者说把病人的病转到灯泡上去，就最终会出现这样的结果。

还有一些很可笑的东西，你比如说研究经方用易学来解释经方，用《周易》来解释经方。最后解释到什么程度，小柴胡汤，柴胡为什么用 8 两？为什么柴胡会比其他的药多了 5 两？这个 5 在《周易》里边是个什么意思？什么意思用的？他就不顾一个最基本的事实，咱们后世用的都不是那个量了，只有那个量的 $1/5$ 。而且我一直跟大家说，我现在用粉剂，这个量还是那个量吗，那差远了， $1/10$ 还不到，然后这是一个方面。

另外你看小柴胡汤，咱们在实践当中，有人就怎么用啊？如果说

你没有发热的话，他可以把柴胡量减少，从疗效上来说，很难说没有影响，但是疗效也挺好，影响不大。那么大家再想想那个《周易》，根据《周易》推出来的那套东西到底有多少价值。你从多大的程度上反映了事物本来面目，几乎一点都没有。那么咱们再从一个更宽泛的面上来说，大家去看看那些热衷于搞《周易》的人，他们现在大部份的人都在干什么？大家想想，恐怕多数人都集中在要么看风水，要么算命。

那么我们整体来看这一条，实际上这就是用玄学来强解经方。他非得把经方这些东西，就是说，甚至就是不顾很多客观现实，你看都有一些不全面的地方。为什么非得要去强调这个阳性病都是发热恶寒，阴性病就无热恶寒，还得是阳性病就七日愈？阳性病到最后，他的最终的意思是什么？你经方的这些东西再好，你得有个理论依据。那恐怕那个时候，这是最先进的一套理论，那么理论是什么，理论就是这个。

所以说，套不上也要硬套，包括我们近代的，不是近代就是后世的，用脏腑辨证来解释经方，大部分也都是这个，都是类似的问题。

太阳病、头痛至七日以上自愈者、以行尽其经故也、若欲作再经者、针足阳明使经不传则愈、（8）

胡希恕：这个根据上面的“七日愈”。那么太阳病啊，七天愈了。那么在七天以上又好了，那就是“行其经尽故也”，到时候了。就是行其经尽的缘故啊，他就不再传了。假设要传呢？针足阳明，那就足三里穴了。这个也不一定，这个就是在这个太阳病啊，在六七天的时候是要传里的时候多，那么在五六天、四五天他传少阳的时候多。他是隔个七日，一般在这个时候呢传阳明的时候多，所以他说针足阳明。那么六七天他也有时候传里的，也有啊，那你针足阳明就没什么用了，这也是就一般人倾向来说的。说这个太阳病啊，在这个七八天的时候，

这是传阳明的时候，如果病不好，有传阳明的可能，那么这时候呢，你针足三里，那么可以使他不传。那么在仲景后边治疗，他不用这个法子，这也是古人有这么一种说法的，是属于针灸的，可以作参考，这个也不一定。

李冠杰：这一条在《康平本》里边，也是降两字格的。这也是出自王叔和的手笔。

从字面上来看，它跟《宋本》字面上有这么一点点差别。就是这个“行尽其经”，《康平本》呢，是“以行尽其经故也”，那么《宋本》呢，“以行其经尽故也”。你看看这个，比第7条还明确一点。要如果说，是有可能抄写的过程当中出现问题，这有可能。抄写有可能抄的时候，后来又改的。这是第二次又改的，像这一类的证据就是里边越弄越多。

所以说，我不是说一时脑袋发热，愣造了一个王叔和二次整理《伤寒论》，整理过两次，不是。你仔细去推敲里边这些东西，像这一类东西，别人没有必要去作这种变动，完全没有必要，只有作者自己，他才可能做这种工作。而且呢，我们也知道后人对待这本书都非常严谨。

那么这个条文的意思呢，我们今天应该这么认识：如果患太阳病后，头痛七天以上而能够自愈的，是因为经络间疾病的传变，已经进行了一个周期的缘故；而如果不能自愈，有进入新一个周期传变的趋势。可针足阳明使经络间的传变中止，即可痊愈。他的意思就是这么一个意思。

那么这个条文里边，这个头疼我们应该怎么理解，它应该是指的以头疼为典型症状，指的是太阳病，应该这么理解，就是说它指的是太阳病。那么这一个条文，实际上是对第7条进一步的解释，理论上他给你找到了着落了。那么具体的，他还得给你找到物质存在的基础。那么是什么？就是经络。他的意思就是想，为什么说是上一段的一个，

就是上一条的一个延伸，一个进一步的解释呢？实际上这就回答了另外一个的问题。

要如果说六、七天不痊愈，我们应该怎么办呢？他是什么性质的问题呢？也就是说他的机理是什么？那么我们应该怎么处理？在条文里边给做了解释。这个“行其经尽”，非常显然就是说在附会《内经》的理论，这完全是来照搬《内经》的理论。那么这里边有个具体的治疗办法就是说，针足阳明，而且他没有说具体的穴位。足阳明本身是一条经络，不是一个穴位。那么，我们今天应该怎么看呢？后世有具体解释的，就说是足三里。

现在是这样，我们把临床实践和王叔和要说的把它分开一下，王叔和想说的什么意思呀？他想说的实际是经络之间已经传够一个周期了，六七天了，这一个周期传完了以后，怎么样怎么样？又进入下一个周期。就是《内经》上说的，它还要传回来，再传太阳，然后太阳再往下传就是阳明，这人已经得了病一个周期了，在这种情况下，你就去针刺阳明呀，等于说强化人体的这一个环节。这个环节强化了，阳明经络气强了，然后它就抵御下一个周期再传进来的能力就强了，好，阻住它了，然后病就不再传了。不再传了，然后病就好了，这完全都是主观臆想。首先说疾病的传变，不是按着那个规律传的，前头我们已经讨论了。再说，实际上针灸里边也很少见到这样的理论。这完全就附会《内经》的理论，就是我给你经方再找一套理论来支持，不管是否合适，他太热心了吧，恐怕是。就根本不合适，愣是往里边套。

但是，我们也应该客观来看，就是我们现在临床当中，有时候针灸治感冒啊，尤其取穴位，当然跟不同的医家手法不一样，取穴也不一样。现在有人针灸的时候，治感冒，治一些表证，也取到足三里，疗效也挺好。但是我觉得这个东西咱们怎么去理解？不要去理解王叔和这个东西那个道理，在这个地方，不一定完全没有道理，这里不是

他说的那个阻断了经络的传变，不是。

我们应该怎么理解？大家去看看桂枝汤，就明白了。这里边最容易说明问题的就是桂枝汤。大家看看桂枝汤五味药：桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣，这五味药里边，桂枝、甘草，除了芍药之外，芍药没有特别明显的改善胃肠功能的作用，如果说有芍药证的话，比如说四逆散，还可以治胃炎呢。我常用四逆散来治胃病，脏腑辨证的人就说四逆散是治肝病的，那不一定。四逆散胡希恕用它就很好啊，就说大柴胡汤证不可下者，如果有柴胡证，就说有明显的半表半里证，但是又不可下，有一点里实，这样的人有时候就说：胃疼。最明显的主诉就是胃疼。如果按按他的心口处，又不喜按，按这个地方有抵抗手的感觉。但是，你要是用大柴胡汤的话，他大便不太好，至少每天一次，而且一点也不干，这种情况不能用大柴胡汤了，那就用四逆散。大家看看四逆散里边不就有芍药吗？芍药占的分量不小呢。大家看看桂枝汤里边，就说桂枝、生姜、大枣、甘草这四味药，都有健胃作用。那么怎么去理解呢？用了一大堆的健胃药，健胃药在经方里边几乎可以说是里证的药了，桂枝不算。用了这么多的健胃药治表证，为什么呀？其实，经方才是把人体看做一个整体的，特别表虚证是一种比较典型的。表虚证就是人体整体来说，就比正常人要虚弱了很多，尤其是肌表这个地方，机能不足、营养也不足。我们可以这么理解，营养也不足，以至于汗毛孔打开都没有能力关上了。

那么这个时候，桂枝、生姜都有直接强化肌表这部分功能，特别是生姜一味药同时有两样作用：第一能走表；另外一个能改善胃肠功能。当然改善胃肠功能，也是适合这种药的情况下。比如说白虎汤证的话，吃生姜恐怕那就是反的了。它能改善胃肠功能，胃肠功能吸收能力就好，吸收能力好，人体的能量来源就充足一些；但是生姜同时呢，我们想像的它又可以把这些能量有目的的送到肌表上来。所以说这就是走表嘛。你看这样，我们治病的过程当中，从经方的方剂里边

我们也能体悟出：治表证，其实药物里边已经兼顾到了里。为什么？就是因为这是一个整体方案。而不是像后世的这些辨证，辨什么？如果是热了，那就得全是凉药；辨你是寒了，你是表证了，用了很多很多表证的药，用了一大堆。一点解决能量来源的也没有，所以说，他们疗效不会好。当然也不是这么单纯的一个原因。我们从这儿能够想到，从这一条里边我们可以得到这么一个启示。但是作者本意却不是要说这个。

大阳病、欲解时、从巳至未上、（9）

胡希恕：这个没有什么理性。这个巳啊，巳时到未，正是天中的时候，午时嘛这个正当中，那么午时的前边就是巳时，午时的后边就是未时，在这个期间呢阳气最盛，在这个一天的十二个时辰来看的。这个太阳病，他是旺于那个时候，热的最厉害呀，那么就在这个从巳至午这个时候，正在这个旺气的时候要好的，要好就在这个时候，这也靠不住。那么这是一个，大概我想仲景，就是出自仲景手，这也根据《汤液经》上的一个照例的文字，也没有什么解释的必要，事实也不一定，可也没人体会这个病是不是准在这个时候好，据我看也不一定的，这也没有什么意思。他这个中医啊，什么他都要解释，可是往往呢，他不是拿这个五行啊，拿这个臆测啊，再嘛拿现象解释。你看我这随便举个例子吧，你看就像这个六七天这个好，那么在西医不算什么，西医他什么病都有个周期性，这什么时候要减轻，什么时候要好了，这个病啊大概的意思，他就是一个病他这个本质上的一种这个进退的变化，没有什么可解释的。中医不然，古人他非要解释不可，他解释不出来道理啊，他就像阴阳五行什么都上来了，他就是这个事，这个用不着解释的。那么这个病必好于什么时辰，因为这个时辰正他旺的时候，这哪对啊，这个就不合理是吧。还有这个，你像这个几日传变他都要解释。伤寒里头是不对的多，那么这个“巳至未上”，这

个东西这个靠不住的。

李冠杰：本条在《康平本》里边，也是降两字格排版的条文。

这个条文比较简单，就说了一个什么意思呢？就是说：如果太阳病要解除的话，在什么时候呢？在上午的九点钟以后和下午的三点钟以前这段时间。

那实际上，他怎么来的这一套理论呢？这也是内经里边的啊，这就是子午流注啊。说是这段时间啊，是人体的太阳经络比较旺盛的时候，那么，他就是根据这个再推导出来，像太阳病一般好都在这个时候。

那么，我们首先说啊，对这一条咱们前边呀，也曾经提到过关于这一类的条文，胡希恕对这一条持彻底否定的态度。它没有任何合理的因素在里边。首先说啊，不管是什么病，我们不管是从经方的理论看也好，还是从临床实践看也好，没有说哪一类的病一定在什么时候可以好，没有这个规律存在。这都是玄学的一些东西，在临床当中得不到验证。比如说还有那个，有的经络是在半夜里边，实际上这六经里边有，他那个“欲解时”，其他的欲解时里边，就有的就出现在下半夜，或者说是半夜里边。那么，半夜里边，谁见过哪一个病一定是在半夜里边好。你像太阳病这个点呀，正好是一天的我们人体就按生物钟来说，人体这个时候是比较亢奋的时候，一天的中间这一段时间。所以说这段时间恐怕也许，要如果说病情正在减轻的时候，这个时候就会明显感觉到，有那个一会儿比一会儿轻的那种感觉，这完全有可能的。

但是说，是不是真正有这样的规律，就是所有的太阳病都是这样。唉呀，还有其他的病应该半夜里好的，都在半夜里边去一会儿比一会儿感觉轻，后来就解除了。是不是那样？这在临床当中根本就得不到验证，别说没法验证，得不到验证，就没有这样的规律存在。而且我们去看看，咱们以后啊，逐渐地，经方的理论学习深入以后啊，我们

也会发现，在经方里边也没有类似的论述。经方治疗疾病，解决问题跟什么时间关系不是特别大，偶尔的。

你看咱们的服药吧，这个方后注里边有的再服，就是一天喝两次，至于说什么时候喝没有要求，有的是日三夜一服，就是说白天喝三次，晚上喝一次，也有这样的方剂。那么，至于说什么时间，也从来没有说特别强调。

其实大家想想，这个条文如果说合理的话，我们应该在经方里边，至少在方后注里边可能就会见到哪一类的情况？你比如说像服麻黄汤，服麻黄汤最好你就在早晨的8点钟服，服下去以后你再盖上被子取点汗，叫他微似有汗，到9点钟左右你就明显减轻了，然后到中午就好了。是不是应该有这样的说法？在经方里边压根就没有这样说法。你要是病来得急了，你要是去看，看一看“伤寒例”里边，有了病不要等，赶紧治，那“伤寒例”里边有。你看看《康平本》里边，他们把条文分开以后啊，大家看一看那些个，我用黑体标出的那些个，就是顶格的条文，唉，有些东西说得非常的客观，非常的科学啊，挺好。

但是，这一类的，就是这种条文，六经里边全都有，成了一个例文了。而且我们后世的研究经方的人，对它解释的是五花八门，五彩缤纷，什么都有，说的都是天花乱坠，这也反映了中医里边一些不良的倾向。就是说，就这么如此没有价值的条文，就把它延伸的，延伸出那么些漫无边际的没有意义的东西，把它延伸出来，实际上一点用都没有。

再说咱们在临床当中啊，反正最起码我自己临床当中，从来都没有考虑过，有时候啊，你比如说这个人中午来拿的药，我就会给他说，你那个这样吧，你如果中午不睡觉的话，一般地说中午，像小孩子如果不上学的话，为了让他这个病好得快，中午吃了饭吃药，吃完了以后就让他躺那儿睡觉，睡觉以后让他盖得厚一点，叫他出出汗，尽量

地这一下午不要起来，到下半下午再说。如果说成年人的话，我常给他说你就晚饭以后吃，睡觉以前，这样呢，你就躺在被窝里边发一点汗，接着就睡觉。其实，这跟那个病什么时候好没有关系，只是一个方便病人这个治病。

风家表解、而不了了者、十二日愈、（10）

胡希恕：这个风家就指的太阳中风者。表已经解了，那么有些余证，犹不了了啊，大概就是在十二日愈了，这也是约略之词了。有的样子呢，这个病都好了，身上老有些酸痛，当然他在自己消了，他自己就好了，不用吃药了，但是一般说来呢，大概十二天他就可以好了，这都是就一般说的，实质上这个病，伤寒病多少日的都有啊，那么后头就有了。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边，也是降两字格排版的条文，也应该看做是王叔和写的。但是，这个条文应该说是比较好的。

那么，这个条文它的意思呢？这个“风家”，就是说常患太阳中风的这种病人。

“表解”，就是吃了药以后，解表了嘛。也就是说常患太阳中风的这种病人，经过合理的治疗之后，表已经解了，但是，还仍然有一些轻微的不适的症状。那么，他有可能到十二天的时候就痊愈了。

当然这里边啊，刚才我们在直译里边就说了啊，这个“风家”，指的就是表虚证，阳性表虚证。那么，表虚证的这一类的病人，它有一个什么样的特点呢？相对表实证来说，他人更虚弱一些，就是说体质比表实证的人要差一些。所以说后边，这一点还挺重要的，你要偶尔的一两次中风的话，那不能叫做是“风家”，“风家”就是说常得这一类的病，身体比较虚弱，在临床当中经常碰到那个见点风就感冒的患者。

我曾经听说过这样的人啊，一个老人，八十多岁的一个老头儿，

他那个冬天就站在外边，天好的时候在外边晒太阳，他是常易感冒。那么，就是容易得感冒到什么程度呢？他坐在北方的墙根底下晒太阳，就是半上午半下午的时候晒太阳，如果说你在他身边走一个人，走的快一点，带的那一点风，都有可能造成他有感冒症状。这让人感觉到都有点不可思议了，这是他家人自己这么说的，反正就是可能也夸张一点。但是就是说很容易感冒这种人，有这样的人，这就是指的这一类的人。

那么，这个“表解不了了”，我们就得把它理解成是他经过了治疗了，经过合理的治疗，不然的话，像这种人他怎么好好的，怎么就会表解了？他这个不了了，说明还有一些轻微的余证，老好不了。

这个“十二日愈”，咱们不能把什么东西都绝对化啊，其实，就算这个条文是王叔和写的，王叔和本身他也没有这个意思，就是说一定是在十二天好，恐怕也没有这个意思。这个“十二日愈”，好像是两个传经周期，咱们不要那么去理解。这就是大概齐的意思，十来天左右，也就是说，你给他治好了病以后，它可能还要延续几天，就是人体有一个恢复的过程。

大家去看看桂枝汤，桂枝汤要如果说加龙骨牡蛎治什么？治虚劳吧。那个桂枝汤加上芍药加点量，再加上饴糖的话，就成小建中汤了。所以说，像得了桂枝汤证的这一部分病人，体质比较虚弱的话，你服了桂枝汤不单单桂枝汤证消失，这个人体的体质也会有所改善。当然这个改善，他会有一个过程的，等于说是还要过几天这些症状才能慢慢消失，是这么一个意思。

另外这个条文还有一个言外之意，言外之意是什么？就像这一类病人，如果说他常患太阳中风证，你给他吃了桂枝汤，他主要的症状好了，他还剩一点余症，比如说打点喷嚏，或者说还有点怕风啊，这样你就不要再治了，这是言外之意。这“十二日愈”嘛，什么意思？你就等几天，给人体一个恢复的机会，给人体一个恢复的时间，他人

体恢复恢复就好了，就不要去乱治了。

那么你治疗的话，再深入地说，你治疗的话，可能往往也没有非常合适的方剂，因为这个他本身还是一个恐怕要吃的话，还得是桂枝汤。要如果说他桂枝汤的症状已经不明显了，其实你在吃桂枝汤，按照经方理论来说也就这样了，你再去吃桂枝汤，至少理论上来说也不对，所以说，这就不要再乱治了。

那么说这个条文，有很浓重的临床经验的色彩。就是说特别像来自临床当中的这么一个体会，治的病人多了，我感觉这类的病人就不要治了，不吃药反而比吃药也许更好些。那这要如果说再想的远一点，恐怕有时候就像比如说病人感冒了，拿我们今天的话说，病人感冒了发烧，然后有汗出，就说桂枝汤证，让他喝桂枝汤，喝了桂枝汤以后，他说我多少还有点头疼，有点打喷嚏，或者说叫他再喝桂枝汤，或者说根据这种情况他又换了别的药了，结果服了以后，反倒是觉得疗效不好，就总结了一个这么的条文。

那么在这儿，有可能大家去看一看王叔和的这些条文里边，后边的王叔和这些条文里边很多的死症。什么意思？就是他碰到了好多治不了的病，那么是不是有一些吃了药以后疗效不太理想呢？可能这里边可能会隐含这个意思。但是有这一层意思，想到想不到都没有关系。所以说这个条文，我们能从这个条文能体悟到就是说需要给人体一个抗病的机会。这是第 10 条。

那么我们今天学条文呢，就学到这儿。还给大家安排了一点内容，是什么呢？就是我这一段时间，想的比较多的，简单再跟大家聊这么几句：

那么我现在感觉，人类发展到现在这个时候，凡是存在的东西都有它自己合理的一面。所以说，我们现在接触到的好多东西、好多理论，你很难找到一个完全是谬误的，完全是错误的，这种东西非常少。所以说，像我们学经方就面临一个选择的问题，就是说都有合理的一

面。

但咱现在还是说一句土话吧，如果说现在按整体疗效说的话，我们的中医没有现代医学疗效好。咱现在先且不说为什么。我们现在说既然这样的话，为什么我们大家坐在这儿，来学中医呢？来学经方呢？是因为经过了慎重选择的，你经过了多方面的了解权衡之后。这就像那个以前山东中医学院的老师，一个资格很老的老教授叫李克绍，大家可能好多人知道，那也是一个经方家。他学医的历程就是这样。

一开始他家里边有人病死，后就发奋学医，在一开始学医的时候，学的是西医。他就是在读一本日本人写的一本西医的书籍的时候，上面有这么一句话，这个中医可以治疗很多病而且疗效很好，但是中医却解释不清楚道理。西医尽管有一些病治不了，没有好的治疗方法，但是却能把病了解得比较深入，认识得比较深，比较客观。李克绍就是看懂了这个观点，扔掉了西医书不再看，就转去学中医去了。他的理论是什么？他的认识是什么？他就是说他解释不清楚道理，解释不清楚道理但是他能治病，我为的是什么呢？为的是治病，我为什么要听你解释那些认识干什么，谁能治病我就去学谁，学成出来就成了一个名医，一个自学成才。后来调到省里边，然后调到省中医学院。现在，山东省中医学院的一些老师都可以说是他的徒孙了。他对经方的研究比较深，有他自己的专著。实际上这是一个选择的问题。就是说为什么选择中医？因为中医有更合理的地方。

那么这里边，如果说我们深入讨论下，这里边有一些很严重的问题。你比如说，一个理论体系，如果说指导思想存在问题，就是他的认识方法，整个的存在方向性问题的话，那么他就会出现许许多多不良的后果。那么咱们再想想，我们中医的整体疗效为什么不及西医？我现在的感受特别深。

我跟大家再汇报一下这个病例。

运动神经障碍的病人，四肢不能动了，他一家人亲戚全都是医生，医院的副院长，内科主任，主治大夫，全是这个，结果一点办法都没有。后来跑到省医院看，给的结论就是运动神经障碍，没有好的治疗方法，原因不明。现在，他今天说吃药，我今天刚给他，这是弄得第几次药来的，两个月不到，3月1号就诊的，现在这才一个月20多天。今天我给他看病，他就说我觉得腿也有劲了，然后整个人的状态也好很多了。他说我在锻炼走路，锻炼得过了，觉得腿肚子有点疼了。而且现在，他有一个非常明显的变化，就是说他的舌质，这个变化太明显了，连他自己的爱人都说，这次看他舌质，一开始他那个整个舌质就像一个灰布，很暗，也没有光泽。几乎你看不到他那个什么有血丝的样子，就是说没有红的那种感觉。现在这个舌质基本上就是那个粉红色的，略微偏暗，就跟正常人的舌质差不多了，就说各种症状都开始好转了。但是他那个病呢，相对来说复杂一些。你看我今天给他的方子防己茯苓汤，半夏厚朴汤，当归芍药散，桂枝茯苓丸，大概这就是主方了，另外还有竹叶汤。我为什么给他竹叶汤呢？因为现在有一点点偏热了，那个睡眠开始不好，因为我跟他说过了，每天早睡觉。以前睡觉很好，现在呢，晚上睡觉有点就是躺下睡不着，所以说白天他现在不睡，就白天不睡，看电视啦，活动活动，他就把觉放到晚上睡，就这样那总的来说睡眠不好。脉搏现在跳的快了，由以前的脉迟，现在变成脉数了。他呢又明显是有虚像，前面这些方子呢，证都有。所以说呢，就给他这么一个方子。那个就说整个这个服药过程当中，基本上是一天比一天轻，各种症状都在减轻，以前那些繁杂的那么多的症状啊，现在基本上就是去了60%了吧。

你像这一类的病，它这是属于一个相对说比较复杂的一点。可是如果说放在现代医学上来说，一点办法都没有。为什么？因为这就是原因。就是他总是把关注的重点啊，放在致病因素上，当他找不到致病因素的时候，他就束手无策了。是不是？

那么我们现在在这儿讨论，就是我经常会说一个问题，还有一个就是脏腑辨证的问题，这不是一个小问题。因为我们现在市面上普遍的都在用脏腑辨证。就是中医几乎都在用脏腑辨证。但是这个脏腑辨证，我为什么就是敢斗胆站出来，可以这么说吧，批判脏腑辨证。为什么？因为那个统计资料不支持脏腑辨证。这个中医治疗，从统计资料再加上经方理论里边，完全应该体悟到这个东西。就是这个疾病跟具体的脏腑病变也没有关系，不能说一点关系都没有，它没有固定的关系。

你比如说一个肝炎，一个肝炎它涉及到 60 个经方，也就是说 60 个经方有治愈肝炎的记录。那么这里边就有大柴胡汤、小柴胡汤、四逆散、吴茱萸汤、半夏泻心汤、生姜泻心汤等等吧，就是说很多方子都有治愈肝炎的记录。那么这里边，明显的你就应该有的结论，尽管这一个确确实实是脏腑出现了问题了。但是你要是按着这一个脏腑治，你到最后就有可能治不了，当然一部分病你是治不了的。但是现在我们实际情况是什么呢？

这前两天，跟一个北京中医学院的一个学生，他以前是山东中医学院的学生，我们两个交流。他现在在北京中医学院读研究生，然后有机会呢，在咱们北京的某大中医院里边实习，最后就跟我说：我就觉得没有信心了，这哪还是中医呀！中医用一个固定的方子去治糖尿病，同时还给病人西医的降尿糖，降血糖的那些药吃。这算下来谁治好的？还有的那些的这个专业的治疗，这都是北京的大医院，咱们不用说哪家医院了。

专业治疗肺病的医院，凡是来的有肺病的这个疾患，那不是医院，是一个医院里边的专门中医治疗的一个科室。凡是来的治肺病的人，都以四逆散为基础方，加加减减。后来这学生问起来怎么四逆散，都四逆散来治呀？也不辨证嘛。或者说我们这个地方，这是人家的专家说，我们这个地方治肺病，我们的特色啊就是以肝论治。大家可想而

知啊，稍有点经方知识的人都知道。要如果说，所有的肺病都用四逆散来治，就可想而知了。这说了肺病了。

就说今天，我的一个病人，他是多年的喘，稍微有点着凉就咳嗽，咳嗽得厉害。后来我给他的是什么呢？厚朴麻黄汤。因为他脉浮，脉洪大，明显的有热，有热像，简单地说他是个厚朴麻黄汤证，我就让他喝厚朴麻黄汤。他喝了以后就觉得，咳喘都明显地减轻了，但是呢就是老吐黄痰。他这个有一个特殊的原因，他找一个算是一个野医生吧，给他外用，试过一种什么样的什么什么药，反正涂上以后呀，说是活血什么的，结果自从涂了这个药以后，他就明显得偏热，经常有上火的感觉。那么这样呢，我这个厚朴麻黄汤下去以后呢，他还是吐黄痰，但是咳喘轻，这说明方剂是对的。而且这个方剂里边有那个石膏啊，石膏如鸡子大，也不小呢，相当于半斤石膏了。后来我又加了一些石膏，加了石膏以后他吃了，是上午吃的下午就给我打电话，他说：这一次这个药可是对路了，他说我吃了以后，浑身感觉，就是肚子呼噜噜的解大便有点稀。我说打住，你赶紧过来。这是我很熟的人，我说你赶紧过来，我再给你一点药，你兑着吃。实际我给他的还是厚朴麻黄汤，但是，我这次做了一点厚朴麻黄汤就没有放石膏。就是等于说，把石膏的量在减下来，石膏量有点过了。但是，你知道他后来给我说什么，他说我觉得这个药如果只是大便有点稀，他说，我觉得这也没事，我觉得特别的轻松。他说以前我这个胸满呀，然后觉得整个这个肺都悬着呀，难受都憋得慌，气也短，我现在觉得里边痛快多了。后来我一看他就不想换药，我就说我不给你换药，我说，如果说你那个药吃的次数多了以后啊，有可能引起你肠胃功能不太好。这样后来他一听，这样，他就今天把药拿走了，冒着雨把药拿走了。

实际上你看经方的疗效，要是说真是用得好的话，那是非常可靠的。但是话说回来，像这样的病人，如果你要用四逆散的话行吗？那就根本不管用，根本什么用都不管。所以说，这个经方不是那么治病

的。

那么我们再推而广知，中医的整体疗效不好，原因在哪？这个问题啊，大家要时刻记在心里，都去找这个原因。为什么？我们也都都知道中医好的，治病疗效非常好。但是大部分人都不好。为什么呀？大家都去客观地找一找原因，到底在什么地方？在我们学习，不断深入了解经方的同时，这是我们必须要找到，我们就面临着这样的任务，去粗取精，去伪存真。

病人身大热、反欲得衣者、热在皮肤、寒在骨髓也、身大寒、反不欲近衣者、寒在皮肤、热在骨髓也、（11）

胡希恕：他有些病是这样的，看着外边是热，而里是真寒，看着外边是寒，而里是真热。这得举个例子，也不是每一种病这样的，有的时候遭遇到这个可能，你看头一个嘛，他说这个病啊大寒，手足厥冷啊，这是里头是真热，所以他不欲近衣啊，那么这一类呢，白虎汤证就有这个情形。这不是厥深热深嘛，外边手脚都凉，可这个人呢他是啊，烦渴引饮啊，不愿衣被啊，正是大热。他这个寒是个假像，这人是吃了白虎汤他这个厥逆就都好了。

还有一种病里头是大寒，这个人这点浮热啊都跑到外头来了，这也了不起了，这都是大病，你像这个四逆汤就有这个情形，通脉四逆汤也有。那么这里头那么样的虚寒，外边呢反不恶寒，脸还有时候发红，这像是外边有热的，其实一点热也没有。他就里头那个大寒哪，他把人的一点虚热啊反倒都跑到外头来了，所以这个大夫也知道，也应该知道。我们在临证哪，不能够只就表面上看我们就来确定寒热了这也不行。他这也是举个例子，后边这个具体的情形有的是呢。

李冠杰：这个条文呢，在《康平本》里边，它是降一个字格排版的条文。

那么根据我们现在所掌握的史料来看呢，这应该是出自张仲景之手的条文。

这个条文呢，我们做一个直译：患者体温虽然很高，反而很想多穿衣服，这是热在体表，寒呢却在体内；那么相反的，虽然体表发冷发凉，但是却不愿意多着衣被，这是寒在体表，热在体内的情况。这个条文呢，大致意思就是这么一个意思。

因为这个条文本身呢，基本上涉及症状不多，而且也非常简单，所以说字面上的意思呢我们就不多做解释了。那么，这个条文被后世一直称作是什么？就说这个条文啊，论述的是真寒假热和真热假寒，是论述的这个问题。那么这里啊，这里的皮肤，不管是热在皮肤也好，还是寒在皮肤也好啊。这个皮肤，我们今天应该把它理解成什么呢？理解成就是体表。那么这里的骨髓呢？我们应该把它理解成，它实际上指得就是我们经常说的，就是指的“里”，就说人体的内部。等于我们中医里边的行话说呢，实际说的是“里”这么一个问题。

那么这个条文，仅从这个字面的直接意思来看，它真实的意思就是想说什么问题呢？它就是想说，当这个体表和体内的症状反应不相统一的时候，那么主要的矛盾应该在体内，也就说应该“里”，里证就是一个主要的矛盾。

你看这个条文啊，就是古人啊写东西比较简一些，实际上啊，这个条文，它涉及的问题应该说是相当得深入，也相当得重要。咱们看啊，它论述的好像就是一个生理现象。有时候这个人啊，会出现这样的情况：体表呢在发烧，但是你从其他的症状来看呢，能够发现他有里寒的情况，所以说这是一种“假热真寒”。那么他论述这个的意思是什么呢？实际上真正的用意在于来指导临床实践，这是来自于临床实践的经验，一个经验的总结。同时，反过来呢，又可以指导临床实践。那么更深一层的意思是什么呢？就是说凡是在这种表里不相统一的情况下，那么里证就是治疗的一个重点。

人家这个条文里边只是说了一个真寒假热的问题。但是我们读古人的东西呢，不能把它孤立起来读。他写这个东西，为的什么？实际上这也是张仲景在学《汤液经》，用《汤液经》上的方剂，临床经验的一个高度总结。

那么他总结这个为的什么啊？这是反过来，也是要论述医理、病理的，实际也是用来指导临床实践的。那么它是怎么指导临床实践的？他的目的就是想说：当表里不一的时候，里就是治疗的主要矛盾。那么从哪儿可以看出来？这没有说谁是主要矛盾。这只说说有真正的里寒、有真正的里热。

那么从这本书的，也就是从经方理论的其他的条文和其他的方剂里边，能够清清楚楚地看出来。你看比如说，像那个四逆汤证。这个四逆汤证，条文里边明文就有，四逆汤证有时候会出现，这是一个典型的里虚寒的而且陷于阴证的一种疾病。那么，四逆汤证就有时候会出现体表发热。

我还碰到过一个这样的病人，这个病人呢，他说前一天呢在外面吃饭，那么吃完饭后呢就觉得肚子不舒服，后来就开始闹肚子，闹肚子以后就觉得肚子痛，这个大便溏稀、次数多。后来我问了以后，他没有其他的明显的症状，他实际上是一个理中汤证。但是呢，他发烧，医院里给他诊断就是肠炎、肠胃炎。这个时候啊，他体温高，给他的药呢，却是大热的药，理中汤，结果在吃了理中汤以后，第一次就开始见效，又吃了两次就好了。这是一个相对地说，算是跟这个条文正好相吻合。尽管他体表温度高，他在发烧，但是像他当时的情况，肯定他也不愿意吃凉东西，他也不会有那种就是说不愿意盖被子啊或什么的，老觉得热的那种不愿意穿衣服的那种感觉，肯定不会有。那么，就会出现这种情况。但是出现这种情况之后，我们再看看治疗方剂，确实用的大热的药。就是说治疗的方剂把什么抛开了？把体表的热给抛开了。

当有表里不相统一的时候，“里”就处在一个矛盾的主要面。但是像这种情况，它本身就符合人体的生理特征。实际上大家都知道，如果一个人五脏六腑没有病的话，他有点感冒或什么的，不治，自己都能好，这个都不是大病，其实道理非常简单。但是在临床当中啊，很容易弄得比较复杂。张仲景之所以特意作为一个单独的条文把它明确出来，就是因为在临床当中很容易治错了。

因为你看到的热，不仅仅是张仲景那个时代存在这样的问题，我们现在普遍的依然存在这个问题。实际上这就是这个条文的一个延伸。那么我们可以延伸出什么呢？大家想，这个问题有点儿重了，那么这是我自己的观点，大家可以去争论，也可以讨论，大家也可以批评。但是呢，这是我自己的观点。胡希恕讲课里边就讲到这么一个问题“甘温除大热”，那么这个甘温除大热，这是一个表面现象。那么它指的是什么呢？就是指的比如说啊，麻黄汤、桂枝汤，这都是甘温的药，总体这两个方剂都属于温药。但是他们的适用症里边都有发热，后人就总结了这么一个理论。就是说，这经方里边全都是实践来的啊，这经方里边这方子治的这些东西没有掺假，都是从实践当中来的，而且可以反复实验的，没有人可以推翻。所以说呢，后世人就给了这么一个解释，就是说尽管用的是甘温的药，中医里边还有这么一套道理，就是甘温除大热。但是，如果说我们仔细想想的话，不对呀。甘温除大热，那个大青龙汤，大青龙汤有没有热？大青龙汤证的病人如果说发热的话，那是热，温度高，甚至把病人能烧糊涂了，而且来得急，有的时候，就几十分钟，就半个小时。半个小时以前就觉得有点发冷，半个小时以后体温就到四十度，我见过这样的病人，很快。那是甘温除大热吗？大青龙汤里边那么多的石膏，实际上那是他有里热了。

所以说，正确的解释应该是：不是什么甘温除大热，而是真正的麻黄汤证和桂枝汤证应该没有里热，甚至里略微有一点点偏寒。那么所以说太阳病常常会表现为恶寒，它至少是没有里热的。这就跟这

一条叙述的，这个人身大热反倒是愿意多穿衣服相吻合了，他本来就是这么一个意思。

那么，我们再进一步地往深里探究的话，我们还会有进一步的发现。就是说当你表证和里证不相统一的时候，刚才我们说了，里证是主要矛盾。其实桂枝汤、麻黄汤本身就是一个典型的例子，只是以前的时候没有人这么解释。它的前提条件，桂枝汤、麻黄汤的前提条件：都不应该有里热。

那么桂枝汤有没有有里热的情况？有。什么情况？咱比如说啊，桂枝加葛根汤。桂枝加葛根汤就有某种程度的里热，大家看葛根不仅仅可以解表，也不仅仅可以治“项背强几几”，还可以治什么？还可以治下利。它所治的下利，就是热利。葛根芩连汤不就是治这种病吗？实际上这就是说人体在这种情况下已经有了里热的倾向了。你才有应用葛根汤的机会。而且一旦有了里热，你再用麻黄汤和桂枝汤，就不行了。

那么，像比如说大青龙汤就是。你一旦有了里热，麻黄汤就不能用了，那么就得用大青龙汤，表实证的。如果我们要讲桂枝汤，那么，我们理解桂枝汤的基础就是：没有里热。当然也不能有明显的里寒。如果说有的话，那也要用别的方剂来治疗。所以说，要用好太阳病的这两个基础方剂，一定要明了这一点。

特别像我们刚入门的这些人啊，一说到麻黄汤就是没有汗的，一说到桂枝汤就是有汗出的。但是一旦有其他因素存在，这个东西就不重要了。任何一个其他类型的疾病，往往都要超出表证本身。

所以说我在这个基础上，近几年我自己通过感悟啊，我提出这么一个观点：就是说表证无寒热。

怎么说表证无寒热呢？不是说表证本身没有体表温度高低的这么一个变化，不是这个意思。而是体表本身温度高低的变化对治疗的影响，没有实质性的影响。

咱就以桂枝汤、麻黄汤看，就能看得很清楚。尽管都有体表热，但是，用的却是温剂。为什么？因为，它没有里热，它至少没有里热，甚至有一点点里寒，所以说就应该用温剂。而且，就包括体表大寒的。曾经有这样的医案，就是白虎汤证。人身上都凉了，都快到休克了，这个时候医者到跟前看了看眼、看了看舌苔，确定他是真正的里热，后来给他吃白虎汤，慢慢儿人就过来了。那么这说明什么？这就说明虽然他表寒，但是一旦有了里热，还是按照里去治。所以说，表的寒热对治疗影响不大。就说是桂枝汤证吧。桂枝汤证有发热，但是你还得让他吃温药。那么让他吃温药的基础是什么？首先说，没有里热在。没有里热在，那个才是主要的。所以这一点是非常重要的。理解这一点呢，对我们用好这个解表剂啊，很重要。

那么我们怎么去理解？所以说，其实现在啊，像甘温除大热，特别是像一些温病学派的一些观点，好多像清凉解表药。这个清凉解表药，如果说有里热的话，大家去看一看胡希恕曾经有一个用这个清凉解表药治疗感冒的一个案例。那大概是他这一生当中为数不多的用时方来治病的，而且都是一些小病。那个人就有明显的里热，舌苔有点黄嘛。实际上还是里的问题，关键的问题不是表的问题。所以说像甘温除大热，或者说是那种清凉解表这种说法，都是不太恰当的，值得推敲。

借这个条文呢，跟大家就说，大家在以后的学习过程当中你去看一看，所有的跟寒热有关的这些方剂，偏寒的或有里寒、或有半表半里的寒；偏热的或者说是，我是说是方剂的治疗啊，也就说治疗对象，就说人体。人体偏寒的，要么有里寒，要么有半表半里的寒；那么，人体偏热的呢，要么有里热，要么有半表半里的热。但是唯独没有说表怎么着了，专门针对着表。咱们从桂枝汤，一开始接触这一个方就已经发现了有这样的问题了。实际上就是说，还是说表证，表证的寒热对治疗的影响非常小。可能在这一方面啊，方剂里边有一点点值得

注意的就是那个竹叶汤。那个竹叶汤是真正的是有点虚得厉害，人虚得厉害。那个呢，值得我们再仔细地推敲推敲。其他的呢，基本上都符合这个规律。就是凡是这个方剂所对的寒热都跟半表半里和里有关系，都是以这个为基础的。

那么这个条文的最后呢，我们想跟大家说啊，我们前边呢，一块儿学习了好几条那个王叔和写的条文。如果说我们再看看这个条文的话，相比之下水平差距之远，又存在着质的区别。

那么这个条文，我想给它作一个总结的话，那么这个条文就是将临床经验升华为医学理论的一个典范。这个应该是这一类的论述，《汤液经》里面都隐含在具体的方剂，具体的证治里边了。张仲景又通过自己的临床实践、临床感悟，又把它升华为理论，充实到这个《汤液经》里边的，这是一个。而且，他总结的这个，经得起推敲，你无论是从生理的角度，从病理的角度，从这个医理的角度，从方剂这方面的角度，从方证的角度，无论你从哪个角度去看，这个条文我们可以这么说啊，这个条文都是真理。它不像我们前边学的那条文，模棱两可。特别是王叔和写的，写成的很多东西都有这方面的那个特点。你要是说往正确方面理解呢，勉强也能说得通。但是你要如果说，往错误方面一靠，它就是一个谬误。这就能看出来啊，大家如果说再品一品，你要是如果说仔细地，没事了拿着这个《康平本》仔细品一品，那些顶格起行排版的那些条文啊，意思更幽深、更准确，应该说水平更高。但是呢，有一些东西呢，你需要给正确的理解。你要是如果说，就是我们直到现在说啊，整个的这个经方理论就存在着，我们现在不能去埋怨古人，古人当时就那么一个条件，就是那么一种环境，给我们传下来这些东西，就已经很了不起了。

但我们现在有一个客观事实在这儿摆着，就是说这么好的这一套东西到最后，发展到我们现在，一千个医生里边，一千个中医里边没有一个人是完全用经方，能够弄得特别懂，一生都在用经方。不是一

千的问题了，恐怕得万里挑一的问题了。那要如果说到这种程度的话，我们不得不说应该解释这些东西，确实就是没有解释。你像张仲景这个条文，这就解释得很清楚。你不管后人怎么去，你再去怎么说它，但是它已经把道理说得非常清楚了。就把这个真热假寒、真寒假热说得很清楚。而且用到临床当中你只要是时刻记着它，你就很少犯这样的错误。

大阳中风、脉阳浮而阴弱、阳浮者热自发·阴弱者汗自出、**啬啬恶寒、淅淅恶风、翕翕发热、鼻鸣干呕者、桂枝汤主之、**（12）

桂枝三两去皮 芍药三两 甘草二两炙 生姜三两切 大枣十二枚擘

右五味、咬咀三味、以水七升、微火煮、取三升、去滓、适寒温、服一升、服已须臾、啜热稀粥一升余、以助药力、温覆令一时许、遍身絜絜、微似有汗者、益佳、不可令如水流离、病必不除、若一服汗出病差、停后服、不必尽剂、若不汗、更服依前法、又不汗、后服小促其间、半日许、令三服尽、若病重者、一日一夜服、周时观之、

服一剂尽、病证犹在者、更作服、若汗不出、乃服之二三剂、禁生冷粘滑、肉面五辛、酒酪臭恶等物、

胡希恕：这条啊，就是承太阳中风那一条，开始不是太阳中风嘛，就是承那一条而申明其证和治。太阳中风咱们头前有一个概要的认识了，那么这个详细的证候和他的治疗，这一节啊，就是接着那个来谈的。“脉阳浮而阴弱”，指这脉说的。外为阳，内为阴。阳浮而阴弱呢，就是指这个脉呀，有浮于外而弱于内的这个形状，实在说起来就

是浮弱。脉，我意思说这个脉呀，轻按浮，那再使劲一按呀，不禁按，弱，非常地软弱无力。

仲景这个脉呀，有的指上下尺寸说的，阴阳，上为阳，下为阴了。也有的指这个浮沉说的，就是外为阳，内为阴，指这个脉的外内上说的。这一节说的“阳浮阴弱”呀，我方才讲了，就是外和内。脉是浮出在外，但不禁按，软弱无力。这个弱脉同这个弦脉是对比的，比如说我们这个琴弦铄丁丁给它上上，一按这个弦呢，上下端直，这叫做弦。你这个弦上得不紧，拿手一按，软弱无力，这个叫做弱。

“阳浮者热自发，阴弱者汗自出”，这个说阳浮之脉，那么为有热之应，就是发热之应。阴弱之脉呢，就是汗出之应，就是由于汗出，脉就弱，脉与证是相应的。

“啬啬恶寒”，这个啬，就是嗦，嗦嗦的意思。冷了，人就拘蜷，就是嗦嗦然而恶寒，就是形容恶寒这个状貌。

“淅淅恶风”，淅淅这两个字，本来是风的声音，微风的声音，淅淅。也有这个淅呀，指着咱们这个淘米的水，叫做淅。所以当水讲也行，当风声讲也行。那么这一段应该当风声讲，本来没有风，太阳中风这类的病呀，老感觉有微风淅淅然来袭的，老感觉有微风吹得慌，其实没有，就是因为出汗哪，感觉外面有风，有风刺激。

“翕翕发热”，这个“翕”，你看这个字，一个“合”字，底下搁一个“羽”字，就是合而不开的意思。这个翕当合，当闭，关闭的闭讲。“翕翕发热”这个意思，就是表证这个时候这个热，弥漫全身，合而不开，感觉着闷热这个意思，合而不开嘛。那么总起来，上面就是发热、恶寒和这个恶风，用一些状词，形容词。

“啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者”，这个表证啊，这个气不得旁达。我们平时这个人啊，皮肤感觉不出透气，其实也是透气的，要不然我们衣服总得清洁，我们老洗澡，衣服还脏，它也往外排出废物，也通透气息。那么这个表证呢，就是不透，不透这个气

就不得旁达，那就往上壅，逆于上，就鼻鸣干呕，这都是气往上壅的一种反应。那么这一节说的是太阳中风的证候，比以前说的太阳中风的证候详细多了，那么至于治疗呢，他用桂枝汤，桂枝汤主治这种病。

桂枝汤这个药物啊，桂枝三两，我们现在不要去皮，这个去皮呀恐怕是个错误。现在干脆有的就把这个去皮去掉，不要了。这个桂枝呀，能够有点发汗作用，就依赖这层皮，这层皮有一种挥发油这种成分。。。。。（音频缺失）。这就是十六两一斤的，它一两合这个三钱，三两不就是九钱吗？可是古人的一付药开的一付单子，它一煎就是三付药。我们现在看这个量呢，要拿三除，比如这个三两，拿三除才一两，那么一两不就是三钱吗，那么现在拿“克”计算就是9克，这个也是约略数，古人的一两合现在的三钱，也是个约略数，也不是绝对准确，但是一般应用啊都根据这个分量差不多，有的说是二钱八九这个样子，也有的说就是三钱，或者还多一点，那么这个也没有一定的考据。历来的习惯呢，就是古人的一两合现在三钱。我们现在呢，又把它变成公制了，就是克了。克呢就是9克，那么其他的分量也都是这样。它这个在汉的时候，度量衡特别小。芍药也三两，甘草二两，炙，这个三两，因为它是三剂，都要拿三除的。生姜也是三两，都要切成片，大枣12枚，把它掰开。

那么桂枝汤根据这个方剂的组成，对于上面这个中风证的治疗，我们要分析分析它。最好我们还要借助《内经》上有这么一段说得非常的好，能帮助我们更容易理解这个药。《内经》有个《评热病论》，这是《素问》里的。首先研究这个汗的问题，《评热病论》上说“人之所以汗出者，皆生于谷，谷生于精”。它意思是什么意思呢？是人所以出汗，就由于饮食，这个谷气，古人说的“谷”就是五谷的谷啊，主要的是饮食所化生的。那么这个谷气不能直接为汗啊，它得在胃经过消化之后，变成养人之精气，这个精就是精气，所以它又说“谷生于精”，就是谷气变成精气之后才能为汗。而拿到现在的生理学上来

把它解释，就是说我们饮食经过消化，吸取的营养成分，血管吸收进来的营养成分供给周身。那么这种营养成分哪，经过吸收这个时候，古人叫做精气。这个精气也是养人，养人之精气，就是精真之气，古人这么样子来说的。

在《评热病论》，它是阴阳交头一节把这个汗讲了，因为阴阳交它也出汗。第二节它又说了“夫邪气交争于骨肉”，说这个太阳病这个阶段，就是在表时候这个阶段。这个邪，就指外邪了，咱们现在说病邪都可以的。与“气”，气就指的精气。“交争于骨肉”，这个骨肉就是说的体表了，他是约略言之。我们这个体表是由皮肤、肌肉、筋、骨所组成的，外在的躯壳嘛，就是人身的外在的躯壳。《内经》上说是“交争于骨肉”，他是概举的，意思就是在体表这一块儿，来相交争，就是互相在这一块斗争。那么这就与我们头前讲的太阳病是一样的，太阳病的时候，就是人身上的正与邪是老发生斗争。“汗出者”，干什么呢？怎么个斗争的方式呢？就是这患病的肌体呀，打算要出汗，把这个病邪解除体外，就是为这个。那么交争的结果出汗了，出汗就是“精胜也”，就是精气胜了，精气胜了邪就解了，这根据这个《内经》上这几句话。

但是精要如果胜，起码这个人能吃东西，为什么呢？他根据头前那个“人之所以汗出者，皆生于谷，谷生于精”，他是胃消化水谷啊。如果精气能把邪祛除出去，而胜了邪了，这个胃气一定旺盛，胃气旺盛人能吃东西，“当能食”。这个邪要是解除了，“不复热也”，人应该吃东西而不复，不再热了，这就是说机体的机能完全胜利的一个结果。那么，“阴阳交”不是这样的。“而复热者”，又还是发烧，这个邪盛也，就是这个发烧还是邪在那儿呢。那么那个汗呐，是精气也，这会儿提出精气来了，那个外边出去的汗呐，是这个精气跑到外头去了。那么如果再不能吃，“不能食者筋骨疲也”，他说如果人再不能吃，这个精气来源断绝了，唯独吃东西他才能够化水谷为精气呢。

如果不能吃东西，只是邪留在人的体内，而邪留着，那样的人活不了了，“其寿可立而倾也”，这是《内经》上《评热病论》有这么一节。

为什么讲这个呢？我们看看桂枝汤，桂枝汤证啊就这个中风证啊，他并不是阴阳交，还能吃啊，没到那个程度，但是他也是汗出而复热呀。你看看这一段就看出来了“翕翕发热，阳浮而阴弱。阳浮者，热自发；阴弱者，汗自出”。他也是汗出，一般这个说法，汗出就不应该有热，这个也是汗出而还有热，那么说明这个精气也是打败仗了，他不足以驱邪，他这个力量不足以驱邪，但是胃可不是衰，还能吃，所以不到阴阳交。那么对这个汗出呢？这个精气不足以驱邪，所以虽然汗出，而邪不去，这么一种病。这么一种病怎么治疗呢？

根据《内经》上的这几句话我们可以理解的，第一个，我们必须促进胃气，增强精气，那么再有汗，病就能解了，因为这个精气力不足以驱邪嘛，所以他出其微汗，可是邪还留着。那么，这样咱们研究桂枝汤就好研究了。你看看这桂枝汤，桂枝汤的发汗，主要在桂枝和生姜这两味药，这都是辛温嘛。这两味药合起来足以使人发汗的，可是这两味药我们再分析分析，这个桂枝汤，桂枝这个药，我们后头也有，他主要治气上冲，气往上冲逆，他能治。那么后边那个奔豚气，所以他能泄奔豚气，这个生姜治呕逆。那么根据这两个药，一个治气冲，一个治呕逆的这种性能上看，他都有下达之性，都有往下的力量，而升发的力量不强。就这两个药合到一起，固然能使人出汗，但是不至于大出汗。凡是大出汗的药都往上升发的力量非常强，旁的咱们没吃过，大葱就吃过，大葱往上升发的力量就强，所以容易出汗，而是容易出大汗。这个麻黄也是，这个药非常的轻，往上升发的力量非常的强。这个桂枝和生姜啊，他都有下达之性，往上升发的力量不强。

咱们讲太阳病也是，他这个汗要出，全是从上体部，所以越升发的药使汗越容易出。他为什么摘取这两个药呢？你看看这个病，“阳浮而阴弱”，就是津液有所损伤了，你再大发汗，那更损伤津液，所

以不要大发汗，采取这么两个发汗的药，而不采取麻黄。那么另外这两个药啊，都有健胃作用。桂枝也是挥发性的药，辛，有点稍甘，那么他刺激胃，也能健胃。这个生姜也是，生姜咱们都知道，古人食不离姜，就是起健胃作用的。这两个药啊，都有健胃作用。同时配合甘草、大枣，这都是纯甘之品哪，甜药，是甜能补脾，补脾就是健胃。所以这个桂枝生姜，再配合甘草大枣，他就有补益胃气的作用。那么这四个药，甘，温，这个甘温搁到一起他又怕出汗出多了。

那么这个病，中风的病啊，已经丧失人的体液了，他出汗嘛，再出多，人得虚下来，这可不行，所以他加芍药，芍药这个药其实不是酸，但是这个药不利于发汗。在本经上说它是味苦，微寒，它这个苦，这个桂枝生姜，是辣呀，辛嘛，用苦以制辛，使辛散的力量更让它小；同时这个苦微寒的药配他这个甜药，还养液。所以一个药的应用两方面照顾，一方面制桂姜之辛，辛散的辛，同时一方面又助甘草大枣，甘药以养液，他这个寒嘛。那么这样五个药搁起来你再看一看，它既是发汗、解热药，这个发汗就解热，我们夏天出汗不就散体温嘛，所以它既是发汗解热，同时又是安中建胃，增加养液，安中养液，滋液的一种药。所以对于上面由于精气虚，力不足以驱邪，虽汗出而邪不去者，用这个正好。精气虚，亢进卫气，增强精气，这样就使邪不得以伏留于肌肉，后面要讲的，这叫解肌。这才能解除这个疾病，这是根据这个药物分析，对这个病的治疗的作用。

那么，我们再来看看这个药，根据后边它的煎服法来说，搁七升水，我们现在不要搁这么多水，他是三服药，他一堆儿煎，取三升。古人的升也小的多，要是大升，一回吃一升，那还了得了。他的一升就是现在一茶杯，你看他每服一升，就像我们现在吃一回药一样的量，没有我们的饭碗大，就像小茶杯那么一杯。他们有考据的，大概是不是现在还有那么东西，他们以前还有看到的，汉时候的一升，就像咱们现在那个大酒盅，东北那块的那种酒盅，大，个儿也是很大，但是

没有碗大，它就那么大。所以我们现在呢，就是一茶杯。那么，这个水就搁三茶杯就行了。你看他七升煮取三升，我们要搁三杯煮取一杯那是蛮好的。不过这点我们还是要考据，就是煎药的问题，古人他用微火煎，这个微火呀，它慢慢的使药的成份溶解到水里去。我们现在这个灶不行，都是用这个汽油，煤气，这火，暴，这样子水要多搁点，按理应该是要用微火，早些时候这个柴火，而且不要让它大，慢慢慢慢煎，所以这个煎药于治疗的作用都有关系。你看我们要炒个菜，火候要不对头还不好吃，你吃这个药，更厉害了，要治病的。我们应该遵照古法，应该用微火，但是现在一般生活条件变了，这个微火也是比较难。要是用那个风窝煤火也行，小一点呀，慢慢煎，那水就可以少搁。否则，这水就要多搁，时间就要跟上。那么这个药呀，他一回吃一升，就是一小碗。而且吃完这个药，你看看他要喝稀粥，要服稀粥“一升余”，比服这个吃药的量要大点，药仅喝一升，这要一升余，以助药力。

你看看这个全书呀，只是喝桂枝汤有喝稀粥，再没有喝稀粥的办法了。什么道理呀？这就是增强精气。它有了甘温的药来鼓舞胃气，在这期间再喝点稀粥，这个精气是要能盛，这些都是挺要紧的。这才足以驱邪，再一有汗，这个邪就解了，不要发大汗。“温覆令一时许”，温覆就是要盖一盖，不盖也不会发汗的，虽然这个药是发汗药，你吃完药，跑外头逛去，也不会发汗的。“温覆”就是多盖点，差不多“一时许”，就是现在两钟头，古人一时辰合现在两钟头。“遍身𦥧𦥧”，“𦥧𦥧”就是微汗。“微似有汗者益佳”，顶好要出汗而不出汗才好，微似有汗，身上发潮糊糊的，那最好了。“不可令如水流漓”，大汗亡阳那就坏了，病必不除，所以这个发汗也要告诉患者。“若一服汗出病差，停后服”，这也要紧，这个发汗伤人津液的，如果吃一服，汗出，病也好了，那后头那个药就不要吃了。“不必尽剂”，它尽剂是三服药，一服药就是吃一回。假若，头一回药吃下去，不出汗，“更

服，依前法”。“更服”，还无汗，方法得变变了。“后服小促其间”，这时候再给他吃呀，这个时间要缩短。“半日许”，就半天，要“令三服尽”。那么现在呢，就是半天内两个钟头吃一回。“若病重者，一日一夜服”，如果这个病比较重，白天晚上一起吃。“周时观之”，就是24小时，古人就是12个时辰。白天晚上一起吃，经过24小时，好好观察。“服一剂尽”，病没完全好，“病证犹在者，更作服”，给他吃第二剂，一剂就是三剂呀。“若汗不出者，乃服至二三剂”，如果汗还不出，可以吃两三剂，三剂就是现在的九剂呀。“禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物”，这是一般服药应该戒口的地方，按理这说都是对的，真要是得热病呀，他也不想吃。尤其这个五辛、生冷，它与吃药是有妨碍的。你看这个药吧，它不要发大汗，你要真吃辣的东西，它就配合这个药要发大汗了，那就不对了，所以该戒口的还是要戒口。为什么这一段我要这么详细的说呢？这就证明桂枝汤不是个了不起的药。

因为现在呀，把这个桂枝看的都是热的不得了。就我们这里也是，你开桂枝呀，这个病发烧怎么还吃桂枝呀？你看看，《伤寒论》是吃桂枝没有不发热的，这个书就这样的，你一看就知道了，而且它非常平稳，不会发大汗的。这是发汗之中讲究养胃增津液的一种办法，不伤人，所以这个药最平稳不过了。所以他告诉你，吃了不发汗再吃，不发汗再吃，就是发汗病没完全好也可以再吃。那么以后，就不每一个方剂都这么说了。因为这个桂枝汤呀，现在也有这个陋习，都不敢用。

在陈修园那时候就有过这个情形，陈修园是福建人，福建就怕桂枝，那也是南方，陈修园用过之后，大家一看用桂枝挺好，那个地方后来也用到四钱五钱，也不咋的，大家还敢用。陈修园在闽候，闽候那个地方要有熟人可以打听，他那边对桂枝后来就不怕了。这是头一节，太阳中风，发热汗出，恶寒恶风，那么这个一定，不一定干呕，这种太阳中风证，可以用桂枝汤，道理咱们都讲过了。

李冠杰：第12条原文是这样的：“太阳中风、脉阳浮而阴弱、阳浮者”，那么这儿呢，我要跟大家说了，这个“阳浮者热自发，阴弱者汗自出”，这个不能算原文，所以说这个原文应该是什么样呢？应该是这样：“太阳中风，脉阳浮而阴弱，啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之”。那么这个条文里边呢，后人在这个条文上加了一个旁注，就是在“脉阳浮而阴弱”的边上拷了一行小字，那么这行小字呢，大家看一下，如果说你手头上有《康平本》的竖排版呢，一看就明白了。那么这一行小字就是“阳浮者热自发，阴弱者汗自出”，这个原文是这个样式的。我们在《宋本》里面已经看不出来了。而且呢，在《康平本》原文和《宋本》的原文里边也有一字之差。就是“脉阳浮而阴弱”，这个“脉”字《宋本》里边没有。但是这个呢，没有原则性的问题。因为不说“脉”，大家也知道啊。也能看出来这是说的是脉。

那么这里我们先说一个问题啊，就是说这个旁注。这个旁注是谁加的？有的人看这个《康平本》以后啊，就简单地给下了定义了，说这些旁注啊，都是王叔和或者说王叔和以后的人加的。实际上不一定。这里面有一种可能性，就是顶格的条文，咱们现在说的这个顶格的条文，顶格的条文，为顶格条文作旁注的有可能是出自张仲景之手。所以说这个旁注啊，大家如果说你再仔细看一看的话，这个旁注，差得很远。有的呢，起到了画龙点睛的作用；那么有的呢，就是画蛇添足。甚至有的就不是画蛇添足的问题，就是起到误导，它就是错了。旁注的那个作者对经方理论根本就没搞通。所以说这里边就鱼龙混杂。

之所以《伤寒论》这本书，我们看到的《康平本》既有嵌注又有旁注什么的。我通过校对啊，我就感觉到这是王叔和第一次整理的时候啊，他是仿效了张仲景当初在整理、补充《汤液经》的这个时候遗留下来的那种遗风。那个时候张仲景就这么弄的，张仲景很可能就加的有嵌注又有旁注。可有一点，为降一字格排版的条文做旁注的，就

绝对不会是张仲景了，没有哪一个人为自己的正文再去做旁注的，这种情况就相对比较少，也不能说绝对没有。也许他写完了以后觉得这个地方还需要再注解一下，也可能。反正这里边有一个是绝对可以肯定的，就是《汤液经》内容的作者很可能就没有他自己的注解。因为我们从注解的内容上看，能看出来。

所以说这个旁注的内容我们需要分析，但是具体到这一条里边这个旁注，还是比较切合原本文本意的。

那么咱们先做一个直译，这个条文用今天的话说就是：太阳中风病，当表现为脉阳浮而阴弱，啬啬恶寒、淅淅恶风、翕翕发热、鼻鸣干呕时，是桂枝汤主治之证。

那么旁注的意思就是：轻取代表发热，而沉取又现缓弱的脉，用我们今天的话说，大概就这么个意思。

咱首先说，这个条文前边有一个“太阳中风”，这个“太阳中风”，类似这样的，实际是一步一步地进来的。古人在这方面搞得非常严谨，它的第1条已经说了“太阳之为病、脉浮头项强痛而恶寒”，然后“太阳病，发热、汗出、恶风、脉缓者，名为中风”。也就是说，先说了什么是太阳病，然后又说了太阳病里边“发热、汗出、恶风、脉缓”的，把它叫做中风，当然下边还有伤寒了。大家再看，我们现在学的这个第12条，你要如果说把它接在这个地方，非常好。那么他就说“太阳中风”具体的表现为什么？表现为“啬啬恶寒、淅淅恶风、鼻鸣干呕”，它就表现为这个，“脉阳浮而阴弱”。它要是具体表现为这个的话，那就是桂枝汤主治之证，桂枝汤就治这一类的。所以说，第2条那个“太阳病”里边本身就隐含着，也就是说第2条里边那个“发热、汗出、恶风”里边还有可能会出现，不是脉缓嘛。这个缓脉是在浮脉的基础上出现的缓脉，那么“头项强痛”也是有可能出现的，“恶寒”也是有可能出现的。

咱们在这儿看一看，这是一脉相承，一环扣一环。看看那两条，

再看第 12 条，12 条前边冠以一个“太阳中风”，就是这么一个意思。说了一些症状，人又恶寒又恶风，具体到是个什么样的脉象呢？阳浮而阴弱，轻取呢是浮脉，你要如果说使劲摁一摁，脉没有那么大的劲，最起码是不紧，是一种缓弱的脉，又加了一个症状“鼻鸣干呕”，就说这个样子。

实际上言外之意，前边的“太阳中风”就包括了第 1 条和第 2 条的内容了，等于说它如果有那两条里边的症状的话，是完全可以的。或者说在那两条的基础上，又有了这些具体的症状，这就是桂枝汤证了。所以说，我们要是这么联系起来看，就会发现古人弄的这些东西，实际上非常严谨。

那么这儿呢，有几个，你像“啬啬恶寒、淅淅恶风、翕翕发热”，恶寒啦、恶风啦、发热的机理前面已经讲了，就不要再重复了。那么这个“啬啬”、“淅淅”、“翕翕”，都是形容词，这个“啬啬”用我们常说的一句话，那个啬就是这个啬，就是形容这个人啊，因为怕冷，给人一种很收缩的样子，特别是体表很收缩的样子；“淅淅”很容易理解了，淅淅沥沥的小雨就是这个淅淅，大家也能从这体悟到，稍微有一点点风，就感觉特别明显，“淅淅恶风”；这个“翕翕发热”呢，我们从字典上查的话，那些解释好像都跟这个原意不太吻合，我觉得胡希恕的解释非常好，就跟人夏天穿羽绒服一样，他就觉得捂得慌，不透气发闷的那一种发热，但是又不是特别的厉害；“鼻鸣干呕”，其实这个鼻鸣，我们完全可以这么理解，近似于我们现在说的鼻粘膜发炎了，呼吸不太畅通，连说话都影响到，现在咱们感冒常出现鼻腔的一些症状；这个“干呕”呢，应该说是气上冲得厉害，影响到消化系统，感觉有时候会出现不舒服、想呕的这种症状。

那么这一条，它所说的是什么？我们给它定一下性，实际上就是阳性表证中的一种虚证，那么虚在哪儿呢？前面我们说中风的时候说过，它就虚在人出现了比表实证进一步弱的这种情况，以致于汗毛孔

闭不上，实际上是一个虚证。跟表实证相比的话，有明显的体能不足的方面。

实际上这个桂枝汤，我们刚才讨论前面那个第 11 条的时候，为这一条做了一个铺垫，我们就说了，首先说桂枝汤适应症既不能有里热也不能有严重的里寒，轻微的一点偏寒是可以的，但是不能有严重的里寒。所以我们可以用一句比较严谨的话来说，桂枝汤证对的是一种阳性的表虚证，不允许存在其他类型的疾病。如果存在其他类型疾病的话，那得按着经方的治疗原则，很可能就没有单独用桂枝汤的机会了。但是真正的桂枝汤在临床当中，它的具体表现也是多种多样的。

咱们这儿有一个临床的统计资料，这个统计资料对桂枝汤的临床表现从好几个方面，对它进行一个归纳总结，这都是说临床医案当中，叙述到的一些用桂枝汤治好了的症状。我们简单地罗列一下，罗列一下让大家有一个印象，实际上经方这个书没有哪一条是跟你说，我这儿是给你的一个，你就是按着这个去套就行了，治病准行，没有哪一条是这样的。因为从多条桂枝汤的论述当中，这个条文里边整体地去体悟，你都会发现，实际上桂枝汤证面对的是挺复杂的一个范畴，它是一个范围，并不就是仅仅的这么几个证。如果你要找不到这个时候，你要没有这种理念，那么你用桂枝的时候，再有其他类型疾病的时候，简单用了桂枝汤可能会出现问题；可能明明是桂枝汤证，但是呢因为你觉得跟书上不太吻合，又不敢用桂枝汤，或者说失去了用桂枝汤的机会，这都有可能有的。

那么这个桂枝汤证呢，你看咱们临床统计当中，出现这种很多的一些像脉证，会面很宽，像恶风寒、头疼、汗出，甚至有的项强，像这个鼻鸣、干呕，这都在条文里边差不多，都有的，有的呢这儿还有，口不渴。山西的一个名老中医李翰卿就曾经，他那个就是叫《伤寒论 112 方临床应用》那本书上，其中他有运用桂枝汤总结的一些经验，里边有禁忌，就是口渴的不可用，口干的不可用桂枝汤，实际上问题

很简单就是有里热了。

舌苔呢，苔白；脉浮缓，或者比如说脉浮弱，或者说是浮虚，或者洪大，还能见到洪大脉呢，这都是临床统计的资料。从这点上如果说我们要稍微想得多一点的话，你就会发现，有很多人现在在宣传他们的像以脉来看病，单纯的脉证，不让病人说话。比方说你不用说话，我给你膜膜脉我就能知道怎么治。那么你看看就光这一个桂枝汤这么多的脉，那么你要是说浮缓的脉，你可能会想到用桂枝汤。要如果说洪大的脉你还能想到吗？有一些东西在临床统计资料的面前，问题就变得清晰多了。

还有像发热、心烦，有的甚至没有汗、乏力、四肢困重，或者说是体痛。大家看这一类的浮数无力，这个脉数哪来的？不是里热，这是因为他有体表的热，就是说发烧了，人发烧以后脉数了。那么这应该是第二部分了，大家能看出来，这一部分的人明显的就是体弱的人，体质比较差的那一种。肢体困重啊，像那种心烦乏力啊，这都是一种虚弱的表现，而不是像有停饮啊。要如果说有停饮的话你光用桂枝汤也不行，后边我们还会详细的说。

那么还有，从第三个角度说说：时时发热，头出现微痛，有汗出恶风寒，心下满就是满闷，还有心下满闷的这种情况。实际上心下在哪儿？不就是胃部嘛，这就是胃里边有问题。桂枝汤有时可以治胃炎，就是指的这一类的。他们表现有明显的表证，有汗出呢，这不是明显的桂枝汤证嘛。脉又浮弱，舌苔也是白的，舌质是淡的，那么这个时候他心下微满，就是说我胃不舒服，有这种可能性。但是你要经过四诊以后发现，他这么多的表证啊，这不是桂枝汤证吗，你用桂枝汤，吃了也能好了，就是他胃病也能好了，但是前提条件得有桂枝汤证。

那么还有时时发热，时时汗出，时有发热，或者说是面部烘热的病人。我见过这样的病人，他说他面部上的那种热，就是跟烤火的一样，一阵过去了。那么有的时候会觉得恶风寒，像这样的情况，有点

像条文里边论述的那种“脏无它病”。

那么第五项，是身体疼痛，或者说有汗出或者说没有汗出，全身困倦乏力，口不干、不燥、不苦，这个口不干、不燥、不苦，你看都是排除其他的疾病。苔白、脉虚或者说是弱，或者说缓，这一类的呢，也有用桂枝汤的机会，桂枝汤的适用证。

还有的呢，是胃脘微痛，或者说这胃里不舒服了，或者说满而闷，或者说干呕，或者说饮食不佳，或者说大便溏泄，舌淡苔薄、脉缓。总地说这个偏里证，没有其他的一些，而且特别是脉象，他实际上实脉，而且没有其他的像里虚寒呢，明显的里虚寒那种，它又有明显的表证，这应该也是桂枝汤证。

还有恶心、呕吐，甚至是呕吐频频的，清痰，就是口水比较多，或说口中没有滋味，吃饭不行，精神也欠佳、乏力，舌淡苔白，脉缓或者滑的，临床医案当中都运用桂枝汤治愈的。

那么我们要如果说把条文做一个罗列，我们把条文整体来看，整个的《金匱要略》和《伤寒论》这两本书里边，论述桂枝汤的条文多达大概二十多条，很多。但是如果说我们要归纳一下的话，不外乎一个是什么呀？一个是桂枝汤的本证，就是说桂枝汤适应证；另外一个呢就是阳性表证经过误治或者说是正治，发了汗以后，或者说是误治，然后比如说经过下、经过吐之后，但是表证仍然存在的，这一类的你就算是没有汗也不能再用麻黄汤来治。这是一类情况。

那么另一类情况呢，就是有里虚寒后，比如说，像四逆汤证，四逆汤证同时他又有体表疼痛，让他吃四逆汤，那么四逆汤吃完了以后，里虚寒的这些证，甚至阴证消失了，没有了，但是，还有身疼痛应该用桂枝汤来治疗。不管他有汗没汗，也应该用桂枝汤而不应该用麻黄汤。

那么还有一种情况，病人没有明显的桂枝汤证，但是他表现为什么呢？因为常自汗出，第54条是这么论述的，经常出汗；那么还有

另一种情况呢，是时发热，就是他定时发热，每天定时发热，发热完了以后汗出，像这类的也要用桂枝汤来治疗。

再一个呢，就是在桂枝汤证的基础上出现了有下利的情况，桂枝汤也可以治。所谓产后风啊，实际上我们这么理解吧，就是表虚的人后来又感冒了，又患了表证，所以说用桂枝汤的机会比较多。像这一类的人，其实条文里边也有，那个竹叶汤，但是那个虚的同时又有里证，又陷于阴证，而且比这个虚得还要厉害，这都是。

那么这个桂枝汤能治些什么样的病？我们也看一看统计资料，下边这些病，凡是有桂枝汤证的，都有用桂枝汤治愈的纪录。像感冒、流感、不明原因的低热、胃炎、肠道易激综合症、窦房结综合症、低血压、腰肌劳损、梨状肌综合症、面部神经麻痹、糖尿病、甲状腺机能低下、妊娠恶阻、更年期综合症、阳痿、小儿夜游症、小儿营养不良、荨麻疹、冬季皮炎性鼻炎、湿疹、多形红斑等等。

还有实际上这也是，从这个临床统计上，你要如果在意的话，你就能从这个临床统计上，能得到很多的启示。桂枝汤虽然说我们称做是一个阳性表虚证，但是所对的这些具体疾病，不仅仅是些表证，但是以表证为多了。你比如说典型的表证，像包括一些皮肤病，我们也可以把它叫做表证；但是像消化道的病，还能说是表证吗？像糖尿病之类的病，甲状腺机能低下这一类的病还能说它是表证吗？它就不是表证，但是它是表证为主要矛盾，以表证的形式反映出来的。

咱比如说糖尿病，这个糖尿病的病人，他的症状那肯定不是白虎加人参汤证的症状，他应该是桂枝证。他这个汗出不是白虎加人参汤证，他没有一点里热，你找不到。而且像脉，他也往往不是洪大脉。

所以说我们从这儿，要如果说你仔细分析的话，你就会发现，再一看这个，你就感觉到，当初我在整理这些资料的时候，我整理完了，我马上就有一种感应。实际上你看我现在经常在这儿，其实我觉得我说这个有点就是说资历不够吧。你看我这儿的场所，脏腑辨证如何如

何？这个药物归经如何如何？但是这个脏腑辨证，大家看看在中医里边，甚至包括现代医学，绝大部份的人都是在搞脏腑辨证，都是在搞那些个具体的，把眼光都盯在具体的病变位置上。

但是要如果说大家从这个临床统计，就是桂枝汤，这还没涉及到其他方剂。要如果说涉及小柴胡汤的话，那更了不得了，那个涉及五脏六腑病都有。所以说我为什么敢直接去说，对于继承了这么多年的脏腑辨证，持一些不同的意见说法。就是因为我有这些资料在，我说话有底气，因为这是事实，你那东西跟这个临床实践不能吻合。

以前的时候没有这些资料，倒退 100 年了，恐怕就没有这种资料，那个时候这么继承来的还有情可原。现在都有了，如果说再那么去看，我们如果说再深一步的话，这恰恰给我们解释了为什么胡希恕对经方的理解是正确的，为什么那些不是按照这种思路去理解的那些人最终不会用经方了？

中医的整体疗效还没有西医好，他掌握了西医到目前为止一点都解释不了的这么先进的医疗手段。但是，整体疗效却远不如西医。问题出在哪儿？这不是很重要的一个点嘛。这是说到桂枝汤所治疾病的临床统计资料上，我们就啰嗦了这么多。

那么这个桂枝汤的方剂呢，我们再具体看看桂枝汤的方剂。桂枝汤是由五味药组成的：桂枝 3 两、芍药 3 两、甘草 2 两、生姜 3 两、大枣 12 枚。这儿桂枝有一个去皮的要求，这个桂枝去皮呢，就说从我知道的这些数据里边，我感觉有一种解释是比较合情合理的。就是说这个桂枝啊，古代的时候桂枝和桂皮是混在一块的，所以说都通称桂枝。那么这样呢，他就要求把桂皮去掉，这样的解释我觉得比较合理一些。不然的话，这个桂枝就变了，就是这个去皮，就变得不可理解了。因为那个桂枝是很细的小枝，桂树上的小枝条，所以说你要如果说，也没法去皮，去了皮以后它的疗效，实际上它的有效成分大部分都在皮上，这是一个。

那另外一个就是甘草，这个炙甘草。我现在临床当中都是用生甘草，你要真要是用炙甘草的话，你得自己来炮制。现在大概药店里面那些炮制恐怕都不大规范，炙甘草和生甘草一公斤里边就差那么一、二块钱，这差了一、二块的钱，他用蜜给你炙，我觉得可能性很小。所以说我一般是不用，我不用炙甘草。当然要如果说有机会自己能炙的话，我觉得还是用炙甘草较好一些。其他的没有什么需要说的。

那么咱们来看看这个方剂里边这五味药，这五味药我们应该怎么去理解？我一直持这个观点，我们对药的认识，到现在说还是停留在很肤浅的阶段。所以说我觉得宁可少说一些药呢，也要找一个准确的，那么准确的标准是什么，准确的标准是得跟临床实践相接轨。

那么跟临床实践相接轨的话，最直接的证据就是经方里边这些方剂和方证。咱们看看这个方剂里边，这个桂枝和生姜这两味药，它两个有共同的特点：一个它们两个都能解表，都是解表剂。咱们大家都知道姜汤煮水喝，就可以治感冒，轻微感冒就可治好，他们都是解表剂。同时这两味药又都是健胃的药。这个方剂为什么还可以治胃炎哪？实际上也是这两味药的作用。所以说，单独从这两味药，应该说这两味药就是这个方剂的一个主药，从解表这个角度来说，这也是两味主药。

但是，我们从这两味药的这两大主要功能上，我们这个地方先说这两大主要功能。那么，这两大主要功能哪来的？它在别的方剂里边有哇，你像小半夏汤，半夏生姜汤，这一类的药都是治胃病的；包括像吴茱萸汤，都是治胃病的。那么，治胃病的里边都有生姜，所以说这个生姜呢，肯定是健胃的，而且我们在生活当中大家也都知道生姜是养胃的。

桂枝呢，它也有健胃作用，你从其他的那个方剂里边也能看出来。这也就是说从临床当中，最起码这两个特性它们都有，既能解表又能健胃。解表的药有得是，大家看啊，你去看解表的药，光是经方里边，

你像防风啊，你像葛根呀，这些解表的药有的是。但是，为什么这专门挑桂枝？当然是临床当中实验出来的，多少药当中筛选出来的，这肯定的啊。

那么，最后为什么筛选桂枝和生姜呢？你看啊，它治的是什么呢？人体有些不足了，汗毛孔关不上了，体表又出现疾病。那么，这个时候，人体不足就首先哪不足哇？首先能量不足，总地说还是能量不足。那么，能量不足，能量的来源在哪？不就来自于肠胃嘛。唉，这两味药就同时既能改善肠胃的吸收功能，同时又把吸收的这些能量最大限度地给你运送到体表，用来解表。所以说，这两味药应该说是桂枝汤的主药。

那么，像甘草大枣，这就是辅助剂了，辅助剂。因为这个，你像甘草哇，大枣呀，这都是又能辅助桂枝和生姜安中养液嘛。就是说它可以，还是说改善肠胃的吸收功能。但是，它们改善的，像甘草和大枣改善的方面又比桂枝和生姜呢，又补充了它们两个的不足，而且，这两个是典型的甜药，都有缓急的作用。

那么，剩下就是一味芍药，芍药这个药很值得人们琢磨。其实我想，我对芍药的理解，芍药甘草汤，可以帮助我们理解芍药的药性。芍药甘草汤治什么？就前两天我跟大家说过的那个医案，上一周的时候，不宁腿综合症，他吃了就好了，还包括抽筋呀，像那个腿肌肉痉挛呐，还包括其他部位的肌肉痉挛。所以说我的感觉呢，你看当归芍药散，当归芍药散在治腹痛的同时，它还能干什么？它还能治贫血。那么，芍药在里边用量那么大，所以说那种腹痛相当一部分的原因也是芍药甘草汤的腹痛相似。但是，它跟血分关系比较大，所以常常会出现在妇女身上。那么，像妇女的一些痛经啊，没有明显里寒的那种痛经，应用当归芍药散的机会就比较多。当归芍药散还有利尿的功能呢，就是说它有治疗停饮的这种功能，咱们先不去考虑这个。那么，就是说我们从芍药甘草汤治的证和病，我们再想想其他芍药的一些方

剂，我们会发现芍药这个药，严格的说它是一个血分药。用它主要可以做什么呢？我记得上一次，我跟病人解释，你之所以有了不宁腿综合症，是因为你的肌肉里边缺少某种营养，这个芍药吃进去以后，就可以改善你人体合成这种营养的机能。那么，我们想想实际上桂枝汤证的表证，这个时候肌表实际上缺少营养，芍药就可以解决这个问题，它能让人体改善促进人体合成某种营养的那种机能，恰好对桂枝汤证有利啊，对治疗桂枝汤证有帮助的。所以说，我是这么理解啊。

那么，这个方后注解呢，我们需要说的啊，一个是这个桂枝汤里边它有一个咬咀三味，就是桂枝芍药和甘草。其他的，大枣是擘的，生姜是切。那么，这三味是“咬咀”。我在谈经方药量的时候曾经跟大家提过这个事，这两个字就是我真正理解经方药量的一个突破口。因为在对这两个字的理解之前的时候啊，我把经方药量的实际临床应用的方方面面，我都有一套我自己的解释。

为什么说我自己的解释呢？因为大家看看啊，直到现在说对这个经方药量都不能统一，这是很不可思议的。人家那个考古发现明明给你说了，汉代的那个折算完了以后，就是汉朝时候的一两就等于 15.625 克。但是，我们拿着这个量套在经方方剂上以后，发现量太大了，了不得，一直就统一不下来。那么，就是说在历史上本来这个，所以说我就怀疑经方这两本书啊，有可能有相当一个历史时期啊，跟失传了差不多，没人用了，已经没人用了，都理解不了，用了净出事。后来就跟现在的日本人收藏一样就把它收藏了，没人用。所以说几百年的时间人们都不太去关注它，后来就形成了这么一种局面。要如果说一直延续下来的话，它的剂量上不会出现这么大的出入。那么，咱现在呢，这个出入解释很多了，标准的解释是一两等于 15.625 克，有的说一两等于 14 克，有的说等于 12 克，还有的说等于其他的，有的说等于 3 克，有的说等于 1 克。说等于多少的都有，就是说各抒己见，无法统一。这要按说在一个医学上来说，这都是匪夷所思，

简直没法让人相信的事。但是，事实上就是这样。

那么我当时呢，就在理解“咬咀”这两个字之前的时候啊，也是，我觉得那个时候我对那个量呢，有我的解释，就是说既要尊重考古的那个实际的数据，同时也要尊重我们多少年的临床实践。就是因为看了这个，就是说认真的对待“咬咀”这两个字，后来再仔细揣摩其他方剂的那个方后注，有的要求锉、有的要求加工成粉剂，这才把所有这些问题都串起来以后，就等于说最终得到了一个逻辑上讲得通，理论上讲得通，临床实践上也能讲得通的一整套的对经方这个药量的一套准确的理解。这是我自己认为啊比较准确。

那么突破口就在“咬咀”这两个字上。“咬咀”是用牙咬，前边我已经给大家说了，就没必要再过多地细说了啊。就是说这个桂枝汤啊，但是我们从这个，可能有人呢，这是第一次听我简单地一说啊，这个“咬咀”的意思就是用牙嚼一嚼，用牙把那个药啊嚼一嚼。

但是你要进一步想的话，之所以“咬咀”它，是因为它比较整。你像咱们以桂枝为例，我们现的桂枝啊，大概我们现在的桂枝的饮片都跟绿豆粒那么大，或者说大的跟黄豆粒那么大，小的还要小一些。像这样大的这个饮片，你根本没法嚼。所以可想而知那个时候，张仲景那个时代或者说张仲景之前，那个桂枝啊是比较长的。你比如说咱们像甘草啊，芍药啊都有可能就这么大一块一块的。所以说可能他在熬药之前，就简单地掰上几掰就拉倒了。所以说煮不出多少东西来，那么他让你“咬咀”一下呢，就是把它放到嘴里嚼一嚼，你像这么大一块一块的你要再嚼的话，就用嘴嚼一嚼就很正常了，很容易理解。那么你嚼一嚼以后呢，嚼的意思是什么呢？就让你把它质地松软了以后呢，可以提高疗效。这不就是很自然的就形成了嘛。也就是说药物越碎它疗效就越高吗。再往下包括那些粉剂什么的就好理解了。丸剂像散剂为什么会服那么少，这就顺理成章了。

那么这儿呢，我们今天学这个桂枝汤呢，还有另一个问题，就带

了一个我们现在临床实际应用当中很重要的一个事，就是桂枝汤这个药是很平和的，很平和。所以说呢，他要求你嚼一嚼，这个嚼一嚼，按它的原量啊，桂枝是三两。三两的话呢，按 15.625g 的话，这就 45g 多了，四十五六克的样子。这个四十五六克的桂枝然后你再嚼了，这个药量按我们今天来看说是比较大了。其他的药呢也是，就是芍药甘草也要求这样。所以说我们今天用的话，大家想一想，今天要用，你要如果说给病人开，让病人回去做汤剂的话，你直接开 45 克是没有问题的，就是说按着它这个原比例，桂枝是 45g、芍药 45g、甘草是 30g、生姜是 45g，这个事没问题的。

但是有一个问题就是，你得按着它方后注里边的这个要求去服药。其实桂枝汤这个药，一个是桂枝汤这个药本身比较平和，另外一个这个桂枝汤你也不可能喝多了，你只要是按着人家这个要求去喝就行了。你看他让你还连着喝，这能看着，你要如果说不汗出的话，你就可以喝了这一碗，过会儿再喝一碗。但是，你要是一旦汗出了，你就不要喝了。这就杜绝了一个问题，你不可能因为喝多了会出副作用，这是一点。

另外一点呢，就是说他也要要求你可以一再地喝，你要是老好不了，也可以多喝几次。说明这个药本身是比较平和的。

所以说我们今天的话，如果说今天，你按 45g，按一两等于 15.625g 开没有问题。实际上，这等于是什么三次的服用量。要三次的服用量的话，其实跟我们今天的这个差不多。等于说你开的是 15g 的桂枝。我们今天呢，开的有的你像 9 到 12g 这是常用量。那么大家看看你到 15g 就稍微多了一点嘛。人家这是三次的服用量。再加上你看这个方剂要求呢，这三次呢，你也可以连着喝，但是一旦出了汗就好了，就不要喝了，是不是？这是这个方后注里面我们应该体悟到的。

再一个啊，这个方后注里面还有一个挺有意思的问题，《康平本》

里边那个，就是“一日一夜服，周时观之”之后，“服一剂尽”以后的这些文字是另起一行的，也就是说这是一个单独的段落。我们有理由相信这段文字啊，不是原来的方后注的内容，是后人加的。不管是谁加的，是张仲景也好，王叔和也好，或是说王叔和以后的人也好，都不要紧。其实加的这些东西呢，你仔细看一看呢，可有可无实际上，没有也不要紧。

你看这些个禁忌啊，反正是我现在临床当中都不要求，我不要求病人忌口，大部分情况下我都不要求病人忌口。这是一个。

再一个呢，这些东西好像多少有一点虚。因为更重要的是什么？在原文里面你像那一个方剂的加减，大部分都是另起一行的，都是一个单独的段落，那根本不是经方里边的东西。这一点很重要，这个地方呢，在《康平本》里边一眼就能看出来。

大阳病、头痛发热、汗出恶风者、桂枝汤主之、（13）

胡希恕：那么这一条有什么意思呢？头痛发热，汗出恶风，这和上头差不多呀！他有用意的，这个仲景的书就这样的，他还怕你呀（认为）桂枝汤就是（用于）中风，中风证，离开这个就不能用了。这段不是了，这段他说凡是太阳病，只要是太阳病，属于这一类的病，他要有头痛发热，汗出恶风，就用桂枝汤，没问题的，你不必管他中风不中风。这是中医辨证的精神，从这书上也看出来。所以这个桂枝汤的主要应用呀，就是在表证的时候发热汗出恶风，他一汗出没有不恶风的，所以这个时候用是没有错的。他这段的意思呀就是怕你由于前一条太阳中风，必须是中风才用，但是后世呀，这条还没人注意。就认为桂枝汤是散风邪的，要不是风就不能用，这是错的。

李冠杰：这一条呢，在《康平本》里面也是顶格的条文。

这里《康平本》和《宋本》有一点小出入。就是这里的“汗出，恶风者”，在《宋本》里面没有“者”字，就是“汗出恶风，桂枝汤

主之”。这也没有什么原则问题。只是这两个版本里面有这么一点差别。

如果说用我们今天的话说呢，这个条文呢就是：患了太阳病后（大家注意啊，这前边冠的是“太阳病”），那么就是患了太阳病后，表现为头痛、发热、汗出、恶风的，为桂枝汤的主治之证。大概就是这么个意思。

但是我觉得啊，这个条文如果说我们再去研究它的字面的意思啊，意义不大了。因为他说的这些症状前边基本上都有。但是这个条文本身，我们很自然地就是说第 13 条和第 12 条是紧挨着的，那么第 13 条又把第 12 条的内容和前边的内容几乎第 1、2 条的内容又重复了一下，而且也说的不全，又把它写出来到底有什么意义？这倒是我们应该关注的。

那么这个条文里面啊，我想咱们是不是从这么三个方面去理解它的意义：第一个，它是一种示范，也就是说它是一种什么示范呢？就是说桂枝汤、桂枝汤证，他可以告诉你桂枝汤证不是一个固定的症状群。你不要把第 12 条僵化了，就认为，尽管他那条里边已经按照我们刚才那个学习法，你把第 1 条和第 2 条融合到里边去，就相对地比较全了。他用这条再给你强化一下，桂枝汤的主治之证，可以是以“头痛、发热、汗出、恶风”为主要表现的，那么也就是说，他可能会有出入，会不一样。

那么不一样，他想说什么？他无非是想说，你不要把第 1、2 条和第 12 条加在一块，就说桂枝汤就是这个症状，不一定。咱们从临床的统计资料上来看，能更全面地看出他这一条的真正意思。桂枝汤证会有一些出入，这是其一，他想说明这么一层意思，桂枝汤证不是一个固定的症状群。其实我们任何方剂都这样。

第二层意思，他还想说明什么意思？说明桂枝汤证虽然不是一个固定的症状群，但是却是一个稳定的方剂的适应证的范畴，他是一个

稳定的范畴。那他是个什么范畴啊？你看，前头第12条太阳中风，他这儿又冠以太阳病，那么这就是太阳病里边的这种阳性表虚证的范畴，你不能出了这个范畴。症状，具体反应症状上可以有差别，但是你不能出了这个范畴，出了这个范畴就不是这个方剂的适应证了。

另外我们还应该再延伸一下，他实际上这是举的一个例子，作的一个示范。示范什么？示范任何一个方剂，都有这样的基本特征，这一点就非常重要了。那么所以说，他后边有一些方剂说得非常得简，简也没关系，你只要是记住这个原则，你再去看那些东西，就是不跟你说证，你比如说，有一些就没有说证，你像那个芍药甘草附子汤，他几乎就没给你说证，你其实也能从中感悟出他的很多症状出来，有方剂在那儿嘛。这就是说，这是古人的一种特有的表达方式，搁我们今天来讲，我们是没有再这么写著作了。

这个条文里边我们还有问题没有了结，看到这儿呢，我在这儿跟大家借刚才这个条文的意思，说一个有意思的医案。

前几天的时候，有一个病人来我这儿就诊，然后他说起来，我的孩子这几天啊，三岁半的一个小男孩。他说我这孩子这几天，他哭啊闹啊，有一句话说得他不愿意听了，他就开始哭，哭得就跟那个泪哗哗的，真是嚎啕大哭。我说，你这孩子身体不舒服，他肚子里边有病。这大人说那孩子，他有什么病啊？我说你那孩子大便干吗？他说，近来大便很干。我说吃饭行吗？这段时间吃饭不好。有时候会不会有没有像呕吐啊，近似于呕吐，吃着吃着东西嘔上一口？有，他说有。好了，我说你这孩子，这样吧，我给你拿一点药，你回去以后呢，先第一次让他喝，第二次呢，给他贴肚脐就行了，我说最多喝两次就行，我给他的就是小柴胡汤。

那么为什么给他小柴胡汤呢？大家听这个症状啊。心烦，哭不就是心烦么，“心烦喜呕”，有时候吃不对就呕吐；“默默不欲食”，吃饭不好，这就小柴胡汤的四大主症有了俩了。像“口苦咽干”，目

前这个孩子说不了，“往来寒热”他也说不了。另外就是他这个大便干，那是这里边有一点热的倾向了，这就基本上。而且呢，他那孩子也没有别的病，我给他多少药呢？给了他 6.8 克，我就弄那么两勺，称了下 6.8 克。我心里边有点数，病历上记录了。拿走了，我给他说啊，一次吃大概 2 克左右，我这儿都是粉剂。

结果，第二天，他给我打电话来，他说哎呀，我们家这孩子就是今天早晨，不知道什么事把他惹了，惹着他了，哭了一次，后来整个这一天一次没哭，而且今天孩子特别乖，一直持续着，今天跟我说呢，大概已经三四天了，孩子一直非常好，很好，一次都没哭过。而且，孩子他奶奶都说，哎呀，就这么一点药就这么管用？结果今天告诉我说，孩子他奶奶看着他，光着脚丫子在路上跑，就现在这个季节，光脚丫子在路上跑，然后还吃了冰块儿，孩子今天中午，就是有点汗出，浑身没劲，看着孩子哪儿也不愿意跑了。老是只要大人一走，就让大人抱着他，然后呢有点发烧，体温有点高，我还没见到，他没来看。我估计他这就是一个桂枝汤证，应该说是比较典型了。现在没来看，我又告诉他，你让他住一夜看看，在我这儿，凡是这种，这一类的小孩子在我这儿看病看得次数稍多的啊，一开始整天输液，后来在这吃上几次药以后，再也不用输液了。后来慢慢他总是有时候会出现感冒发烧啊，我总跟他说观察观察，他有时候第二天就好了。

后来大人就这么说，我经常咨询你这儿，后来我就成了这么一种，慢慢就成了我不怕发烧了。孩子发烧不是很高的话，我就让他多喝点水，休息休息，他有时候，常常就能好了，我何至于再去着急给他看去呢。

实际上就是这样，我们现在很多病啊，都不仅仅这样，很多病都是，有时候不治就完全可以好的。你比如说失眠，有的人是在身体恢复的过程当中这个内脏的功能，某些功能偏于亢奋几天，老睡不着啊，其实你要如果说，不管他，四五天也就过去了。但是非得要吃个安眠

药啊，到医院吃点这药，吃那药，结果把这种状态就稳定住了，里边恢复过程停止了，就成了慢性失眠了。其实你要是不管他，四五天就过去了。

以前的时候，很早以前我也不太相信这个，后来再在自己身上体验到了，这是。

另外呢，就是桂枝汤证。我们怎么去全面的理解桂枝汤，因为咱们学的这是第一个方剂，面稍宽一点，对大家理解这个经方啊，会有所帮助。那么实际我们这个桂枝汤的临床应用，我们现在真正单独应用桂枝汤的机会非常少。你像刚才说的这个小孩子，我觉得十有八九，他可能单独用到。

另外我用桂枝加附子汤，也不算单独的桂枝汤了。我记得比较明显的一个，就是一个老太太，六十多岁一个老太太，体质很弱，很瘦，白白的，她是平时很少得病，加上那次天也挺冷，她回她老家，老家村里边，见村里边人啊，兴奋说话就说得特别多。她回来以后就感觉是感冒了，然后鼻塞，就是鼻子不透气，有点流鼻涕，自己感觉发冷，当时体温还不高，后来他孩子带她来我这儿看病，后来我就想了想，就给他桂枝汤，桂枝汤喝了一次就好了。好了以后，但是呢，后来又给了她两三天的都给喝了，其实这就是，这是一个单纯的一个，前提条件是什么？没有其他的证，当时她说的就是轻微的感冒。我们找到的证，就是就比较简单，就说那个呢，是比较典型桂枝汤证，其他的我们单独用桂枝汤证的机会不多。理论上说，凡是阳性的真正的单纯的阳性的表虚证，只要是这个范畴，基本上都是。这就是桂枝汤的应用范畴。

但是，我们经方里边对桂枝汤的论述，涉及到桂枝汤的这些论述，把整个经方的药物的应用说得非常透彻，我们在这儿，大家可以看一看，我把问题集中了一下，大家可以看一看啊。

刚才说了，桂枝汤的正确应用，那就是阳性的表虚证。但是你实

际应用当中，真正的阳性，单纯的阳性表虚证不多。要如果说从表证的这一个角度说，如果说它伴有表实证呢，你看啊，咱书上就有桂枝麻黄各半汤，桂枝二麻黄一汤。那么我们在这儿再延伸一下，有没有麻黄二桂枝一汤？也完全可以的。只要是能辨证精确，完全可以，这就是等于说给我们举的例子。那么这就是一个合方的问题，就是虚实错杂。实际上，就说阳性表证里边虚实错杂了，错杂了按照它各占的量，再去把方剂合到一块就行了，这是一种情况。

那么另一种情况呢，已经陷于阴证了。陷于阴证以后，尽管他还是表虚证，但是，不是阳性表虚证了，是阴性的表虚证。那么他这儿呢，就有桂枝加附子汤，这是一个也等于说是给我们举了一个例子，桂枝加附子汤。

那么还有一个方剂呢，是桂枝附子汤。这个桂枝附子汤是附子量就大了，它量大了以后，尽管也是表虚证，也是阴证，但是它侧重不一样，那个侧重于应该是痹症。这是陷于阴证，就是说表虚证如果说陷于阴证的话，实际上就方剂也要做相应的改变了。那么如果伴有里虚寒的证呢，有桂枝人参汤嘛，也就等于说是桂枝汤合理中汤的合方。那从这个方剂大家就看出来了，一但有了里寒，里寒就是主要矛盾了，加一个桂枝就是理中汤加一个桂枝就可以了，这又是一个方面。

如果还伴有里实热证的，像这个白虎加桂枝汤呀，这个白虎汤加桂枝也属于典型的有里实热了。

这是指的表虚的，像大青龙汤是表实的，跟这个不一样。

如果伴有水证，也就是有了其他类型的疾病的，伴有水证。伴有水证的话，你像苓桂术甘汤、茯苓甘草汤、苓桂枣甘汤、桂枝去桂加茯苓白术汤，这些方剂都是对各种情况呢，既有表虚证，又有停饮的。

但是从这个地方，停饮这是经方里一个很重要的治疗原则，不管是什么表证，一但有了停饮，这个对表影响是非常大的。所以说，在

治疗上变化幅度也比较大，大家也能看出来，方剂上不是一个单纯加减的问题。

所以说你看啊，我用苓桂术甘汤治过感冒，用那个茯苓甘草汤治过感冒，它都能治好了，但它得有那个证。

如果伴有半表半里证呢，柴胡桂枝汤这就是一个典型的方剂啊，桂枝汤和小柴胡汤的一个合方。

如果伴有里热证同时兼有水证的话，就是体表停饮的话，那么这种情况还有桂枝二越婢一汤。

如果有里实呢，用桂枝加大黄汤。

如果伴有经水方面的疾病，这个经水方面的疾病，我们如果说归类的话，经水方面的疾病应该归半表半里证。那么，它还有桂枝加龙骨牡蛎汤，桂枝甘草龙骨牡蛎汤。

如果伴有阴性表实证的话，有桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤。其实如果它没有水证的话，合上麻黄附子甘草汤行不行？也不是不行。

实际上我们从现在这个角度看，是不是都是些举的例子。但是如果一条线地往下学的话，大家都会觉得这就是一个一个的方剂，我们学这个方剂怎么用？其实你要换角度看呢，大家看看是不是这个经方是一个很活的一套体系呀，它们不是死的。

如果伴有津液虚的，还有桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤，这是一个比较典型的津液虚的一个，就是桂枝汤证出现津液虚的情况。

如果伴有气证的呢，你看桂枝加厚朴杏子汤，桂枝加桂汤。桂枝加桂汤就是这个桂枝加了二两，整个的方剂所对的那个适应证就发生了变化了。

大家看啊，你看经方既有它非常严谨的一面，又有非常灵活的一面。所以说怎么去把严谨掌握好，怎么又在临床当中把灵活变化好，这都需要我们好好地学习。

如果伴有痹症呢，有乌头桂枝汤。这也是一个阴性证吧。

那么在这个桂枝汤的基础上有出入的，症状有了出入。是桂枝汤的证，但是呢，症状上有出入，要如果说是桂枝汤所覆盖的范围，没问题啊。像我们刚才说的那些证好多桂枝汤不用加减了。如果超出了桂枝汤覆盖的范围，那么你还得加减啊。你比如说桂枝加葛根汤，桂枝加黄芪汤，桂枝去芍药汤，你还得加减，根据情况。

实际上这些都是些例子，你说它是例子吧，既不能把它当公式学，又不能把它当做一个那个很随便很随便的一些。就是说跟我们工厂里加工东西，你这个材料、原材料我随便加工成什么都行，又不能那么理解。所以说我常那么说啊，经方不能随意加减，但是又不能不加减，主要是看你对经方理论学的、掌握的程度怎么样。

这也就是说我们通过这些分析，这一个桂枝汤展现了一个什么？展现了一个活灵活现的立体的经方体系。所以说，以前我曾经写过一个小贴子，就是张仲景给我们留下了多少方子？你怎么去算呢，像他给我们示意的这些合方，其他的不能合吗？完全能合。那么用得好和不好，关键取决于我们经方理论的水平了。

昨天，济南的，复兴中医网站上管理层里面的一个人员，两年以前的时候吧，我去济南的时候，我到他那儿，我们聊了半天。这次呢，他跟他的一個朋友一块儿过来的，在这儿呆了一天。就在我们这个聊的过程当中，来了一个病人。这个病人呢，等我们有机会的时候，我想我会跟大家比较详细地说一说这个病人。这个病人啊，我前边曾经给大家提过两次，因为他病程比较长，而且他整个这个疾病呢，从濒临死亡，从这么一种程度，他是一个肺结核，而且是有二十多年病史的这么一个肺结核。他从那种状态一直到后来，到慢慢接近正常人，再后来慢慢去上班，然后呢到基本上就跟常人差不多。一直到现在呢，就是服药呢，还不能说完全停药的，过一段时间，他就到这里，有一些原因的。那么，昨天也正好这个病人就过来了，他稍微有一点咳嗽，

不严重，但是喘、短气，另外呢，就是他觉得腹满，特别是上腹部满，不舒服，再就是感觉胃这个部位啊，有疼痛感，这是他主要的症状。因为前几天碰见过他，问过他，他大便有时候一天还两次，大致是这么一个情况。因为他一直在我这里看病，时间长了以后，他的基本情况都比较熟了。也没有把脉，也没有看舌。但是我觉得啊，我要如果说用药的话，还缺少一个证据，就是他的腹满，是一种虚，还是一种实，然后我说我得给你做一个腹诊，然后就摁了摁他肚子，摁了以后他的胃这个地方啊，就是咱们经方说的心下这个地方明显有抵抗感，就是说摁着他明显得硬，而且呢他也不愿意让摁，你给他摁呢，他就说里边有点满得更厉害。另外他自己说那个胃痛啊，不过他自己感觉不是胃里边痛，是肚皮痛，就是说他就说胃外边这个肌肉这一层痛。我当时就给了他大概有十克多一点吧这个四逆散。给他四逆散之后呢，当时我就跟那个济南来的朋友解释，我就说我为什么给他四逆散呢？现在是一个实证，另外呢，是他呢又不可下，不能用大柴胡汤，他大便呢，有时候还一天两次的情况，还有呢，就是他这个腹痛明显地他自己说部位比较浅啊，在浅表这一层，我说应该是一个芍药甘草汤证，我说四逆散里边就包括了芍药甘草汤了。这样呢，我就给他四逆散，其他的症状呢，比如说里实呢，四逆散就解决了。这样，药给他以后，我告诉他，这些药吃两天，然后吃完了以后再回来看。结果今天早晨晨练的时候，我碰见他了，因为他上夜班，他下夜班，我呢就出去跑步，就碰见他了。碰见他，老远就下了车，他说：昨天你给我那些药啊，我昨天晚上吃了一次，我感觉全好了，我剩下的药还吃吗？我说没关系，你剩下的药吃了吧，你把它吃完了。吃完了以后，如果说还有什么不舒服的话，你再来看一下。

这个病人啊，他最初吃药的时候啊，吃的主要的方剂是小柴胡汤合上小陷胸汤。那么这里边呢，就有一个按照我们经方辨证，他始终是半表半里存在着状态不好的情况。那么以前的时候呢，是虚的，现

在是实的。而且在这之前，大概有一个多月到两个多月之前的时候，我还给他看过一次，那时候天还有点冷啊，那一次给他看的，给他吃的什么药？真武汤又合了一个什么方子。那就是一个以里虚寒、水证为主要的，那么他当时就是那个证。他吃了以后也是，他后来见了我就说，哎吆，这一次药我吃了以后见效非常快，非常明显。再往前，后来我就跟济南的朋友啊，把他的病历看了看，这一个人啊，现在他就是隔三差五的来，已经是两年多一点的时间吧。那么，整个这个期间，他的病情呢，是逐渐地减轻。但是用药这里边，又特别是最近这半年用药里边明显的由虚变为实了。那么这个药里边用到像桂枝茯苓丸啊、像厚朴三物汤啊，还用过那个旋覆代赭汤，而且，大概是一年前以前的时候有一次明显的感觉，是你从脉象看，从舌像看，没有明显得热。后来呢我就给他用过一次桂枝加厚朴杏子汤，结果就那一次用得不太好。后来他就说，这次这药吃了效果不明显。到后来他介绍给别的病人，就说人家这里看病，每次吃一点药就管用了。

这里边就有几个，一个是辨证准确，再一个就是病啊，经方治病治的是什么？治的就是人体患病以后的疾病反应，就是证。其他的，那么重要不重要？未必不重要，有没有参考价值？也有参考价值，好多因素都有参考价值的。但是，不能离开这个方证。也就是说不能离开证。所以说其他的，像体质也好、或者说某某具体的脏腑也好，某某具体的病变位置也好，那个都有参考价值，但是最根本的还是要看证。

大阳病、项背强几几、反汗出恶风者、桂枝加葛根汤主之、（14）

葛根四两 芍药二两 生姜三两切 甘草二两炙 大枣十二枚擘 桂枝二两

右六味、以水一斗、先煮葛根、减二升、去白沫、内诸药、煮取三升、去滓、温服一升、覆取微似汗、不须啜粥、余如桂枝法、将息及禁忌、

胡希恕：这个“项背强几几”啊，“几几”这两个字是像形字。这个本来是成无己注呀，就是伸脖子的这么一种形状，伸颈状，他也解释明白这个意思了。实质这个字你查字典没有，是说小鸟学飞的时候，它这个羽毛不丰啊，飞不起来，脑袋往前伸伸的样子，叫做“几几”。那么由于这个项背特别强，强就是拘紧呐。这个脖子啊萎软不自如，就叫做“几几”。伸着脖子，左右的运转不自如。那么这个太阳病，现于这个“项背强几几”的这种情况，“反汗出恶风者”，这搁个“反”字，它后头有这么一段，它说“太阳病，项背强几几，无汗恶风者，葛根汤主之”。它冲这一段来的。它说太阳病，项背强几几，全是由于无汗而恶风，用葛根汤。那么现在呢，搁个反汗出，与那个就不一样了，那个无汗，而这个是反汗出。这个字的用意呀，特意搁个“反”，干什么呢，让你对这两个方剂作个鉴别。全是“项背强几几”，无汗者是葛根汤，有汗者就是桂枝加葛根汤。这搁个反字啊，就把这个内容给揭示开了，搁个反字让你比较，就是让你比较那一段，那么后头就快讲到了，这是两个方剂应用的主要鉴别点，葛根汤和桂枝加葛根汤。那么这个项背强，就是项背这个地方肌肉发痉挛，它痉挛的厉害，就是痉病了，就要背弓反张了。轻者就是“几几”然，就是脑袋别扭，脖子伸着运转不自然。这是肌肉的关系，肌肉发痉挛。这个葛根汤，葛根这个药，在本草上说是，主消渴，身大热，是个清凉性的解肌药，而有作用这个“项背强几几”，就是项背肌肉拘急呀，葛根汤有这个作用，有这个医疗上的作用。

那么其他都是桂枝汤证，别看他没写，这个太阳病就贯穿了，然后太阳病汗出恶风，就概括头前那两段了，太阳病，头项强痛，怕冷啊，同时再有汗出恶风呢，这就是桂枝汤证。但是“项背强几几”桂

枝汤治不了，所以他加一味葛根，这个葛根呐，有治项背拘急的特能，所以加入到桂枝汤里头，它就治桂枝汤证而项背强急的这么一种证候。

那么这个方剂呢，这个书上是错的，麻黄不应该有，有麻黄就是葛根汤喽，后头单有一个葛根汤，这个赵开美本他搁个麻黄，你们把它勾掉。而且这个药物的分量也不对，这个芍药、桂枝也都应该三两，他是桂枝汤的加味，就是桂枝汤加上四两葛根就对了，旁的应该照旧就对了。那个葛根汤啊，桂枝和芍药都减量了，这个书啊把葛根汤搁这个地方了，这不叫桂枝加葛根汤了，所以这个是错的。在书上应该把它改了，麻黄去掉，芍药搁三两，桂枝还是搁三两，那么这个方子的煎服法与桂枝汤一样，但是不必喝稀粥。我们在临床上应用呢，就是桂枝汤证，一切合乎桂枝汤，同时项背强几几。太阳病只是项强啊，这个牵连到背了，非加葛根不可。

李冠杰：这个条文呢，在《康平本》里边就是一个顶格排版的内容。

这个条文今天做个直译：患了太阳病之后，表现为项背强几几，反而汗出恶风的，为桂枝加葛根汤主治之证。

那么这儿呢，这一条里边啊，因为我们才刚刚学到了第 14 条，实际上在以后的条文里边，类似的条文非常得多。他这个条文里边冠以太阳病，就是说前边条文之首就是太阳病。那么这个太阳病，我们再看看，这个太阳病在这一条里边我们应该怎么去看它？你既不能简单地把它看做是一个表证，又不能简单地看作太阳病提纲里边的，他就是有那些个共性的症状，也不能那么看。那么我们应该怎么看呢？其实大家看一看啊，古人写的那些东西啊，好多东西你得联系起来看，这是当时古人大概跟它当时的写作条件是有关系的，养成了这么一种论述的习惯。这样可以用最少的文字来说明最多的问题。

那么，这里边的这个“太阳病”呢，首先说，他最起码得有这么

一层意思，就是说他有太阳病的典型的症状反应，他应该有。那么具体是哪些，并不是一个固定的症状群，它是一个综合的东西。那么，具体到这一条里边呢，我们再去看看，条文的后边有。有什么啊？“反汗出恶风”，这个“反汗出恶风”呢，这个“反”字的意义呢，我们后边再说。那么先说“汗出恶风”，“汗出恶风”是什么意思呢？也就是说，他这个地方论述的这个太阳病，有后面“汗出恶风”的这个症状存在，那么，就跟太阳病提纲里边的那个太阳中风，也就是说跟第2条里边的太阳中风证是相吻合的，因为他有汗出。那么这儿呢，因为有后边这一个症状的存在，整个的这个太阳病，就给予了太阳病的一个明确的界定，前边的这个太阳病并不是泛指所有的阳性表证，而是指的是阳性表证里边的一个表虚证。为什么啊？因为有后边的“汗出恶风”。这样呢，结合起来以后，他的意思越来越明确了。

那么如果说我们要再结合“项背强几几”，这又多了一个症状，而且这个症状呢，在太阳病里边，也有。那么，你再结合后边的方剂，你就可以得出这样的结论，尽管这个条文大家看啊，就说了两大类症状：一个是项背强几几，再一个就是汗出恶风。前边呢，又加了太阳病三个字，就这三个点，组成了一条线。那么他要论述的内在的内容是什么？实际上就是：太阳中风证的基础之上，又伴有桂枝汤主治之外的症状。那么怎么这么说呢？大家看，汗出恶风和太阳证结合起来以后，这就是一个桂枝汤证，但是你看后边的方剂呢，它是桂枝汤加葛根。也就是“项背强几几”不是桂枝汤所能治得了的，那么太阳病在这儿，就有着比较重要的意义。

所以说啊，初读《伤寒论》的人，总感觉到不知所云，字面意思其实很简单，也不是说哪一个条文有多大篇幅，没有，非常简洁。而且你要看他意思说呢，本身也是比较明白的，如果说你不能这么理解的话，那么这个条文好像前边是症状后边是方剂，就是说条文就是在症状和方剂之间简单地划了一个等号。但是当我们把这些东西都联系

起来看的话，唉，他里边说了，他不但说的内容很多，而且还相当准确，一点都不含糊。他都是得互相参照着看。这是这一条里边的“太阳病”。

那么，“项背强几几”，这个呢，我们不去做过多的解释了，因为“项背强几几”这几个字啊，凡是了解一点伤寒论的，了解一点经方的，因为它太特殊了，这两个字就太特殊了。“几几”这两个字，是个像是一个几字，但是呢，没有这个勾。对于它的解释呢，大家也都很熟悉了。最初的意思就是小鸟学飞的时候脖子往前伸着，想飞飞不起来的那种样子。然后呢，把它借鉴过来以后，来形容患者因为后背后颈部的拘急不适，感觉特别得不舒服。其实我们最形像的啊，最常见的，就是落枕。落枕以后啊，那个感觉就很形像。

另外呢，就是这个“反汗出恶风”。这儿这个“反”字啊，原意就是说：本来不应该有汗出的，但是在这儿却恰恰相反，出来了汗出的症状。那么，本来不应该汗出，这个本来跟谁比较啊？跟后边的葛根汤。跟后边的葛根汤如果说相鉴别的话，这是一个很重要的鉴别点。我们到以后，学了葛根汤以后，其实你可以翻开葛根汤看看，葛根汤和桂枝加葛根汤就一味药之差，就差一个麻黄。

那么如果说简单地总结一下呢，这一条实际上论述的就是一种阳性的表虚证而且伴有“项背强几几”这么一种特殊症状的病理状态。

实际上我们可以简单地把它叫作，这个“项背强几几”我们可以把它直接称做是“葛根证”，但是这个不太确切。因为我们后边还会讨论一些具体的病，这些具体的病里边，比如说是颈椎病，治疗颈椎病不一定全是葛根剂，这个值得我们注意啊。如果咱们要这么说的话，只是形像好记，有很多地方呢会这样说。但是自己心里都应该清楚啊，经方里边，经方的辨证，就是一个辨证体系。

这个辨证体系有很重要的特点：就是任何一个单独的脉，一个单独的脉象或者说一个单独的症状，都不能做为用药的依据，必须有其

他的证来做佐证。但是有的证呢，有比较明显的代表性，你比如说这个“项背强几几”，他是用葛根的机会就非常多，相对说就多了不少。

另外你比如说往来寒热，凡见往来寒热，只要是稍熟悉一点经方的，你很自然的首先就想到什么？想到柴胡剂。但是呢，真正治往来寒热的，也不是仅仅柴胡剂，还有别的。那么这个呢，在我们今后的学习当中初步有这样的理念，就是说学经方理论啊，不应该把问题僵化。

那么（桂枝加）葛根汤的方剂，我们大家也读一下吧。

葛根四两 芍药二两 生姜三两切 甘草二两炙 大枣十二枚擘 桂枝二两

“葛根四两、芍药二两、生姜三两切、甘草二两炙、大枣十二枚擘、桂枝二两”。那么我在这儿为什么要读它一下？本来我们像这个大家手头上都有资料。那么为什么要读一下呢？（桂枝加）葛根汤这个方剂，在《伤寒论》里边是个比较特殊的方剂。那么它特殊在哪儿？特殊在《宋本》和《康平本》有明显的差别。这个差别里边那么我们现在啊，今天大家就能深切地感觉到，我们为什么在学习的时候，每一条我们都会说它在《康平本》里面是个什么样的东西。为什么要这么说？咱们先看这个方剂。

这个方剂我刚才读的这个药物组成，是《康平本》里边的。但是《宋本》里边这个方剂有麻黄三两。那么它有麻黄三两，如果不深究的话啊，好像感觉它就是或者说把方剂抄错了，这是比较深一点的意思了，浅层次的就是说它出了笔误了。但是实际上啊，这个你要如果说去仔细地分析一下《康平本》和《宋本》的差别，这里面会给我们带来很多信息。

我们首先说，如果看《宋本》的话，《宋本》在这个地方，当时宋朝的校正医书局的林亿他们，在这个地方经过反复地核对以后，他就发现了这个方剂的问题了。那么发现问题以后他作了一个按语，那

么按语呢是这样的：“臣亿等谨按仲景本论，太阳中风自汗用桂枝，伤寒无汗用麻黄。今证云‘汗出恶风’，而方中有麻黄，恐非本意也。第三卷有葛根汤证云：‘无汗恶风’，正与此方同，是合用麻黄也。此云‘桂枝加葛根汤’，恐是桂枝中但加葛根耳”！他说得很明白了。他就说啊，他经过核对以后，他也参照了其他的条文。桂枝汤说了，是治汗出，自汗出，那么那是中风；伤寒呢是无汗，用麻黄。那么这个条文里边明明说得很清楚，就是有汗出恶风，但是方剂当中却有麻黄了。可能这里边有错误。就是这么一个意思。那么他又往后又进行了进一步的佐证。然后就说，葛根汤条文里面就有“无汗恶风”，而且方剂跟这儿的方剂是完全一样的。那么所以说，这些因素加在一块，就证明是什么？这个方剂恐怕是桂枝汤里面只是加了葛根，没有麻黄。意思就是说没有麻黄。

但是大家再看《康平本》，《康平本》里边没有，压根就没有麻黄。那么这里边我们先说一个匪夷所思的问题，应该说是一个必须正视的一个问题。那么这里边，凡是喜欢动脑子或者说喜欢深究《伤寒论》沿革历史的这种人，都会想到这个问题。那么会不会是某些人，比如说是因为这个《康平本》是从日本传回来的，那么是不是日本人他出于某种学术上的目的，《宋本》既然他们已经校对发现这个问题了，然后他就在《宋本》的这个基础上把林亿他们的这个按语去掉，把方剂中的麻黄去掉，然后改成这个样子呢？这种可能性非常得小。因为不是一个方面能证明啊，《康平本》不可能是由《宋本》改写的。在这一条里边呢，要如果说那种假设的话，让人感觉到还不能排除这种可能性。但是呢实际上，你要如果说再去看其他的条文的话，其实我们今天学的条文里面就有，你要看其他条文的话，那这种可能性是没有的，不可能。没有人能做出这样的事来。

那么所以说这儿呢，我们就再反过来再看一下。你看，那么这个方剂就出现了，实际上我们又应该说啊，它实际是把葛根汤错抄在桂

枝加葛根汤里边了，错抄在这个地方了。那么为什么会犯这样的错误呢？还有一点，就是《康平本》没有，这非常非常有意思，就说《康平本》不是。

那么《康平本》不是呢，前边我跟大家讨论的时候曾经说过，我通过校对《康平本》，我得出一个结论，就是王叔和曾经第二次整理《伤寒论》，也就是说他第一次整理完了《康平本》的样式，那么第二次整理，整理完了以后是近似于《宋本》的这种样式。那么这样呢，大家看啊，恐怕就是在他第二次整理的时候，就是我自己这么想，没有任何的依据，只是我就是向大家说自己的想法啊，突然有这么一个想法：

王叔和那个时候是比较有社会地位的人，我想啊，他第一遍整理《伤寒论》的时候，很可能是真的他自己下了很大的功夫。你比如说是往里面加旁注啊，《伤寒例》里边他加了些内容，包括条文里边他加了 140 多条内容在里边。那么第一遍他肯定是下了很大的功夫的。但他第二遍整理的时候，他只是定了一个基调，一些要紧的地方他给又调整了一下，比如说像段落的位置，像第 80 条里边的三个小段落，后来移到了第 59 条之后，这个呢，他肯定要发话的。如果说不是他说的话，别人是肯定不会做这样的事。但是我想很可能他第二次整理，他只是调整了某些地方以后，是由别人来抄的，是由另外的人来抄的。所以说，这就有可能出现这种情况。就是说他抄到桂枝加葛根汤这个条文的时候，或许因为某些原因他中断了，中止了，他又去做别的事，然后回来继续抄的时候呢，他总有一个他要写的一个卷，他有原书的一个卷，所以说他再打开原书的时候，或许他正好打开了那个，或者不管什么原因吧，这个事就很难再具体了啊。就说很可能就在抄的时候，他恰好看到了葛根汤。然后因为葛根汤这个药物组成，或者说也许他前边抄了一半，后边这几个药一看是一样的，再加上这个人也许对医学不是很懂，他也许就这么抄上了。要不然的话，你很难做出，

因为这个错误太低级。而且这里边，这是一错到底，包括方后注里边也跟着错了。所以说，等于就是这个方剂就是错抄了葛根汤了。

那么我们还能看出另外一个事，一个是，后人从宋朝校正这本书开始一直到我们今天，后人对这本书的态度相当得严谨。实际上王叔和一开始也非常严谨，当然他往里边加那些东西，是出于他的学术需要，如果他不持一种严谨的态度的话，我们看到的《伤寒论》已经不是现在这个样子了。特别是当我们看到《康平本》以后，你会发现，王叔和当时的态度也是非常严谨的。这是一个方面。就严谨到什么程度？你看林亿他们，明明从各个方面都证明了这个方剂就是抄错了，但是他并没有改，而是加了一个按语。并不像我们后来，在整理《伤寒论》的时候，《伤寒论》里边这个新加汤没有方剂，就给它加上吧；哪个地方谁谁讲过，这个字是错的，就给它改了吧。不应该这样，因为古人的东西就是应该保持原貌，正因为保持原貌，我们今天看《康平本》，就会发现里面给我们携带了很多的信息。那么这是一点，就是说后来的人对这本书的态度相当得严谨，每一个字都看得非常得重，都不会轻易地去改。正是因为这样，才给我们今天的研究提供了一些相对比较可靠的资料。

另外一点，顺便我们还能从逻辑上推出来，当时宋朝校正医书局的那些人在校正《伤寒论》的时候，他们手头上是没有《康平本》的，这点也很重要。为什么？因为如果他有《康平本》的话，这个方剂他就直接改就行了，因为他校正，也参考了好多版本，我们能从后边的按语里边，其他的按语里边，能看出来。

另外，他当时在校正《伤寒论》的时候，还没有见到《金匱要略》，这个我们在学甘草泻心汤的时候，甘草泻心汤里边少一味药，但是《金匱要略》里边有，他写了一个注，他也发现人参少算三两不对，他就写了一个注。其中有一句话，就说他校对各个版本都没有这三两人参。但是，《金匱要略》里边有。这说明什么？说明他没有见过《金匱要

略》。这个时候《金匱要略》还在书库里边被虫子咬着呢。就是说我们从这些版本里边，它携带了很多的信息，如果说单纯地去看《宋本》的话，这样的信息你就得不到了。

那么这个方剂就是桂枝汤原方加了葛根一味药，加了四两葛根。大家注意啊，这里边它已经不是桂枝汤的原方了，实际上不是原方，桂枝量都减少了，减少了一两，桂枝成了二两。那么我们从这儿能看出什么？能看出古人用药非常得严谨。加了葛根以后，葛根本身也是解表药，解表的力量强了，把其他解表的药就相应减少了一点用量。

我们从其他的方剂也能看出这一点来，比如柴胡桂枝汤，实际上是小柴胡汤和桂枝汤的合方，但是合方以后药量都减了，等于说是各取了一半。

那么这儿我们不仅仅从药量的变化上看出古人用药得严谨，同时我们还能体悟到另一种东西。《伤寒论》上这些方剂的用药量，我们可以这样认为，这是比较大的一个量，我们可以想像，那时候的古人，医疗条件非常差，他们当时看一次病，其实我现在想想，我小时候，很多邻居，也是这样，稍微有一点病，有点不舒服啊，在家里边都想一些土办法，我就见过。现在看就是患有里寒的那些老太太，她们就经常是晚上做饭的时候，在大锅底下那个土灶，在那个灶里边，做完饭以后用一块砖扔在里边，用做饭的底火的余温把砖加热，拿出来拿毛巾包一包，晚上用来烫一烫肚子，治一治她的里寒，就说这一类的偏方很多。为什么？就是因为医疗条件不好，再加上当时人们的经济条件又不好，能不看病的就不看病，非得到了非常严重的时候再去看病。大家想想汉朝时候，恐怕比我们近代几十年以前好不了多少，恐怕这一类的情况也非常多。所以说医生治病就得讲究一个准、快，经方的药量相对来说也是比较大的，我们从这儿也能体悟出来。

你看就是这个桂枝加葛根汤，加了四两葛根以后，桂枝减了量，像桂枝这种都是比较平稳的药，还减了量，这是我们从方剂当中看出

来的问题。

那么这个方剂，实际上桂枝汤我们前面已经说了，尽管桂枝有一点量上的变化，但是没有质的差异，那么我们应该把它理解成桂枝汤的基础上加了一味葛根。那么实际上我们理解这个方剂的话，葛根就是一味很重要的药。葛根这味药，是一味寒性的解表药。因为很长时间了，我一直在关注着，你看中医凡是用方剂的人，用的不都是中草药嘛。如何去理解药？这是一个很重要的问题。所以我呢，长时间关注这个问题，后来我发现，实际上这个药和病和方剂都应该是统一的。如果说不统一的话，就没有意义了，而且统一起来以后，我们会发现经方是一个完整的体系，它应该是这个体系里边的。所以说，我跟大家介绍药的话，首先就是它对应的辨证要素里边对应的是哪些内容。看这儿，它是一个解表药，也就是说它是一个治疗表证的药；另外，它是一个寒性的药，寒热里边它有寒热属性，其次才是它的具体功能。我们从经方里边完全可以看出，其实它有治疗热性下利的功能，而且它有改善人体后背部和后颈部的机能的特征。后边我们会讨论一个病，你会从中感悟得比较深一些。

那么另外呢，我们从有葛根的这些方剂的疾病里边，我们还能看到葛根对人体体表神经方面的一些疾病呢，有明显的治疗作用。所以说呢，在这方面我们后边会讨论一些具体的病，就会感觉很清楚了。

另外呢我们看这个方剂，不要单纯地把它作为一个孤立的方剂，特别是围绕着桂枝汤。经方理论的创造者们下了很大的功夫，这是给我们作了一个非常规范的示范。那么这个桂枝加葛根汤，我们也应该把它看作是这是古人给我们作的一个桂枝汤加减的示范。就是说前边这个条文我们已经分析了，它已经很明确了。这个方剂治疗的是什么？就是太阳中风证。也就是说具体的就是治的桂枝汤证的基础上又出现了“项背强几几”。但是“项背强几几”这个症状不是桂枝汤所能治的了的，所以说呢，这儿就必须得加上可以治这种症状的药物，

那么就加了葛根。

我们再从这个意义上推而广之，在其他方剂里边，你比如说像桂枝加黄芪汤啊，桂枝加附子汤啊等等的，实际上都是这么来的。因为出现了桂枝汤覆盖不了的症状，就必须得加减。那么，我为什么一直在强调，这是古人给我们做的示范。

为什么强调这个呢？我在这儿跟大家说一个，就是近期我自己的一个体悟吧。因为春节，整个春节期间，我一直在整理这个《康平本》，这个整理《康平本》啊，以前的时候没有这么郑重其事地整理过。你看整理这东西，你看校对它是个挺麻烦的事，这个手里边拿的是《康平本》，那么这边呢放着是《宋本》，然后在电脑上呢，还有你最终要完成的一个版本。那么也就是说你得把这三个点上完全都把它对起来，那一个点上都得，都得对照。然后呢，逐字逐句地，每一字，因为《康平本》和《宋本》之间哪一个字出现了差异，不同的字，不同的句子，不同的段落位置，这些都得给它找出来，都得做个注。所以说有时对的过程当中，就这么说常常都忘了喝水，你最后对的时候，你对一段时间觉得累了，稍微一活动才发现：哎唷，我怎么就这么直蹦蹦地坐着，就没有靠在这个靠背，就是坐椅的靠背上，靠在靠背上会多轻松啊。但是你不由自主的就这样，非常紧张，就是说挺疲劳吧。但是过了春节以后，时间不长我就开始有颈椎病吧，有点不舒服，后来慢慢变得有点疼。这个时候呢我就，看自己感觉感觉，平时想吃点热东西啊，或者说少活动活动，就是还是有汗出，再加上这段时间也没有明显得热，然后我就喝了那个桂枝加葛根汤，喝了二天。另外还有一个，我这段时间刚刚进来了新的葛根，我也想顺便试试看看它怎么样？喝了二天以后我感觉不对了，它没有经方那个疗效，没有那么快，后来我就停药了，不喝了。

我就在想原因出在哪呢？后来过了二天，我就仔细想了想，多少有一点点这个小便不利，就是有时候一上午有一次，或者说都没有。

你想尽管说是，你像脉象啊、舌像啊，都没有特别明显的那种证。但是我自己感觉吧，那么我又加了，就是桂枝加葛根汤，又加了茯苓、白术。实际上也就等于说像经方里边有这样的例子，就是桂枝去桂加茯苓白术汤，那么就加了这二味药。喝了一天，这一天喝了三次，我的量呢，大家都知道非常少，这一天喝完了以后，第二天就明显地减轻了。在第二天我没有喝，就慢慢地一天比一天轻，那么就轻起来，现在呢基本上没有什么感觉了。

实际上，这才是我们应该想到的，学经方时你最后得，这叫学进去，你能准确的理解这个方剂。然后再能理解这是古人给我们举了一个例子，这是给我们做的一个示范，然后你再学出来。把经方整体的理论能够化作自己的东西，能把它真正学成自己的东西，那么你自己就可以再根据它的理论，你就自己可以组方了。当然还说都不能，经方呢不能这个，又是不能离开经方的原则；再一个呢不能作太大幅度的，你总得说有依据，不管是幅度大小都得有依据。

那么下边呢我们再说方后注。这个方后注解啊，因为这个《宋本》是误抄了葛根汤了，所以说方后注解里面呢，多了一个麻黄，那个六味药成了七味药。然后呢，又多了一个，还有一个“去上沫”，这个呢，都是桂枝加葛根汤里边没有的。

另外这个方附注，方附注咱们不念了，大家自己看一看就行了。另外这个方附注里边有一个跟桂枝汤不一样的地方，就是特别强调了不需啜粥，你没必要再去喝粥了。那么这里边大家看这个方剂加了葛根以后，解表的力量就比较强了，恐怕是你要如果说喝了粥以后，可能会造成汗出的量比较大一些，恐怕把人给出虚了，这个古人在用方上非常得严谨。

那么桂枝加葛根汤的适应证相对地说呢，比较单纯，我们学了这个桂枝加葛根汤的适应证，就是这个方剂的适应证，实际上就是桂枝汤的基础上又多了“项背强几几”，但是这个项背强几几，我们从它

治疗的疾病来看，范围还会要宽一些。甚至包括比如说，面部神经麻痹，这个面部神经麻痹就跟“项背强几几”，恐怕可能说会伴有项背强几几。那么这个时候呢，在“项背强几几”的前提下，又出现面部麻痹的话，再有汗出，你用桂枝加葛根汤的机会就有了。像发热啊，恶风寒哪，汗出、头痛，像舌质比较淡、苔薄，脉浮缓等等。这都是，其实跟桂枝汤的症状出入不大。

那么下边呢，我们再看一看，有应用桂枝加葛根汤机会的现代病。我在这就跟大家简单的罗列一下就行了：颈椎骨质增生、颈椎病、关节疼痛、肩周炎、肌肉劳损、跌打损伤、半身麻木、面部偏侧浮肿、口眼歪斜、面神经麻痹、重症肌无力、僵人综合症、慢性多发性肌炎、特发性震颤、荨麻疹、风疹、头痛、眩晕、目斜视、肩凝症、落枕、胃痛、痢疾初期、急性肠炎、流感、胃肠型感冒、高血压、麻疹初期、疹出不畅、神经官能症、抽搐、多发性脑动脉硬化、破伤风等。

大家听听它治疗的疾病，这个范围还是挺宽的。而且这里边我想是这样，因为经方治的是证而不是具体的病，所以说我们对这些病，我们凡是能收集到的资料越多越好，我们不去做很规范的界定。你看这里边好多，你比如说头疼，这个头疼严格说就不太像是一个症状，而且不太像一个具体的病，没有关系，只要是它对我们理解这个方剂能够起到帮助，我们都把它拿过来，我们从中可以从各个方面来感悟这个，更全面的感悟、体悟这个方剂。那么这样呢，我们就把这个桂枝加葛根汤方方面面的呢，基本上都是从学这一条条文开始，我们基本上都说到了。

那么这儿，我们进一步地讨论一个具体的病，就是一个最常见的病，颈椎病。本来呢，这个颈椎病我们完全可以放到葛根汤里边去讨论，但是我想，像这一类的内容越早提出来越好。再一个就是，我们见到的这个颈椎方面的一些疾病，很多人还真是桂枝（加葛根）汤证的比较多一些。所以说呢，我们来从这一个具体的病里边，我们简

单地分析一下。我们看看能够从中得到些什么样的启示？

那么这个现代医学对颈椎病，我们可以这么说，现代医学对任何一个病都投入了很多的人力、物力、财力去研究它。特别是对疾病的底层的一些病理，都有比较细致的研究。那么对我们来说，这是非常有帮助的。

我们可以从中西医两个角度来对比，来权衡一下，看看互相之间有什么差异。那么现代医学怎么认识这个颈椎病呢？它是这样给颈椎病下了一个概括性的论述：颈椎病是指颈椎间盘退行性病变，然后就是颈椎肥厚增生，以及颈部损伤等引起的颈椎骨质增生，或者是椎间盘脱出，韧带增厚刺激和压迫颈脊髓、颈部神经，包括血管，而产生一系列症状的临床的一个综合症。那么主要的表现为颈肩痛、头晕、头痛、上肢麻木、肌肉萎缩严重，严重者呢，上下肢痉挛、行走困难，甚至四肢麻木、大小便障碍，出现瘫痪，而且呢，这种病多发在中老年人，男性发病率高于女性。这是现代医学对这个病的一个比较笼统的论述。

但是要如果说我们中医呢？在中医里边，其实对这个病也有很多的治疗方法和有相应的解释。那么其实总的说，不外乎就是，更具体的经络的话，就是足太阳膀胱经了。那么要如果说，不说这个具体的部位气血流通不好，大概不外乎这一类的解释。但是我们从经方的这个角度看，这个问题远不是这样，你说前边说的这些有道理吗？有道理。是事实吗？也都事实。但是你要如果说换一下角度，你突然就会发现，他们是片面的。

那么为什么这么说呢？凡是得这一类的疾病，你看颈椎病、腰椎病这一类的病，没有说这一路痛下去的。当然说，你比如说有的人医疗条件好，或者说治疗正确，他很快治好了。实际上人们关注的就是这些。那些没有条件治的，或是压根他就没想治，这部分人会出现什么情况？很少有人去研究他。实际上，我们身边比比皆是，就我自己

身上，我就经历了不只一次。

那么现在这么说，我在电脑前边，一天在电脑前边大概十来个小时，持续了已经十多年了。所以说我的颈椎，那是倍受考验的，我到严重的时候，我的颈椎到什么程度？我跟大家说，大家可能会觉得挺好笑，我最严重的时候，我得，平时看电脑，那个时候不是液晶显示器，把显示器放在桌边上，我坐在地上，我把地上铺上一个棉被，我坐在地上，我身边放一个凳子，凳子上边放鼠标。为什么？我得昂着脸去看，大家看过放风筝的吗？我得昂着脸去看。要如果说我平视显示器，跟我现在就跟大家这么交流的，就这样子，这么平视显示器的话，几秒钟我都受不了。我颈椎严重到这种程度，但是那个时候，我用了一年半的时间把它治好了，没为它吃过一点药，我没吃过药。而且，我也没有按摩。

那个时候我正是在验证一套理论，就是通过理疗的办法来增强体质，它那个理论增强体质以后，你的体质好了，他就会自己恢复一些疾病。恰好那个时候，我就想验证验证，尽管我知道什么方剂可以治，我就不去治，我就去验证验证。后来随着我身体状况逐渐地好转，我颈椎病逐渐地在轻，但是很慢的。大家想想一年半，那个时候我还经常，后来就在地上坐着累了，然后就坐在凳子上，然后再把桌子上放着一个凳子，把显示器再放在凳子上边，还得说那么看，后来就慢慢地…你看就现在，每天就十来个小时在电脑前边，都很正常的，都没有事了。那么，其实我这是比较严重一点的，你像轻的人，他这几个月比较难受，但是，他比如说没有条件治，或者说他也没去治，过几个月他几乎没有感觉了，差不多好了。那么，那些病变它会自己好吗？就像咱比如说现代医学研究的那些病变，那些病咱们大家去看看没有哪一个病在短时间好的。那么，这种结论，是不是这些疾病的症状，就是现在我们简单叫做“项背强几几”啊，这个“项背强几几”是不是就是那些压迫神经造成的？

我们再换一个角度来看颈椎病。去年在中央十套节目上，那个《走进科学》节目，曾经就有这么一个节目呢。请了治疗颈椎病的高手，用手法治疗颈椎病，当时就在节目的现场，就当时表演，在台下的观众里边现找的病人，上来以后，那个大夫也是比较有经验了。他根据他的经验，先是用手摸一摸，然后呢，问那个地方疼得比较明显，然后这个时候他就有了一个，根据他的经验啊，他就知道用多大力，往那个方向来给他扭转，实际做的时候非常简单。就是把这个病人的头夹在这个腋下，使劲一扭，那个病人就当时噉的一声，结果扭完了以后，病人后来动了动说好了，没事了，真的没事了。但是，这个大夫啊说得非常客观，你像说他这个病人，前边拍过片啊，在医院里边检查过，说是生理曲度变直，说我给他治他好了，可能很长时间，停几个月，甚至几年他也可能不会复发。但是，你如果是到医院里边去拍片，他的骨头还是那个样子，并没有发生变化。

那么，这就奇了怪了，那么他怎么治好的？大家想想怎么治好的？实际上这个道理呀，前边说的这些东西呀，都有一定的道理。但是，就是不能完全解释这个病。就像这种用手法治疗他就解释不了。那他怎么好的？他就扭这么一下，那就什么骨质增生啊，什么那些…什么韧带增厚啊等等，那个能解决了吗？不能解决的。那么，为什么他好了？咱们中医的解释还是比较有道理的，虽然说是浅，还是浅，就跟现代医学是一个思路。就认为你这个地方病了，你的病变在这个地方，就按着这个地方去找原因。

但是，你反过来再看看，从经方的治疗里边，从经方治疗方剂里边，你再去体悟一下，大家去看看桂枝加葛根汤，如果说你把桂枝汤去了，单纯的服葛根，这个可想而知，难免说一点疗效没有，可能也许会有一点疗效，但是，疗效绝对不好的。那么反过来说，如果我们把葛根去掉，你只喝桂枝汤，那恐怕疗效也不好。就算你是桂枝汤证，疗效也是非常不好的。大家你就可以想，这个桂枝汤在这起什么作

用？桂枝汤实际上这个时候，我们在学桂枝汤的时候我们已经说了，桂枝汤它本身就有有一个健胃，改善肠胃功能的那么一个病理，增液嘛，它改善肠胃功能让你吸收得好，然后把能量输送到体表，输送到体表以后，恢复你一些肌表功能，也就是说提高你肌表的抗病的能力。桂枝汤有这个功能。但是，它对“项背强几几”这种症状却疗效不好。但是，我们如果说单独用葛根也不行。那么，用了葛根以后呢，葛根就把桂枝汤所产生的能量，最大限度地用来改善咱们项背的这种部位的，叫什么？改善他的状态吧，生理状态，实际上是改善营养水平，这个地方的营养比以前好了。

那么，我们从这个地方反过来再推，到底怎么去理解颈椎病啊？这已经非常明显了。那么，颈椎病怎么得的？首先是你这个人整体来说健康水平降低了。那么，你这个人健康水平降低了以后，我们打个比方啊，比如说这个工厂有十二条流水线，那么，它的供应科每天预备十二吨的原料，每一条流水线要供应足额一吨的原料，才能保证这个每一条生产线的生产。但是，如果说你这个供应科供应能力不足了，你手头上只有十吨的原料，这个时候你就会克扣某一个生产线，当然你要如果说都平均分配，也不是说不可能。但是，人体却不行了啊，这就是像人体，咱人体就这样。那么，有时候，你比如说啊，要如果说只有十吨原料，这十吨原料他只供给十条生产线，那么，有两条生产线就要闲置起来，设备和人员都得闲置，明显的就不合理了。是不是？他要是说克扣某一个流水线的 500 公斤，那么，这一个流水线就要闲置 500 公斤的产能，是不是这么个道理呀。

其实人体就是这样，人体最理想的状态是每一个部位，每一个细胞都有充足的营养，这是最理想的。但是，当你人体营养供应不足的时候，人体开始趋于弱，能量供应不足的时候，它不是相同水平的下降，总是有某些器官得到的能量偏少，或者说呢，有某些器官消耗的偏少。他消耗的能量，尽管整体供应不足了，但是，他消耗却没有下

降，他消耗还是那么多，他依然是相对说他都缺乏营养了。大家想想颈椎病，腰椎病之类的啊，都是这样的情况，人体总体能量不足了。但是呢，你的工作呢，比如说司机、会计、电脑操作员，他恰恰就是，特别是看文本，看文本啊，他跟那个看电视节目不一样。你要如果说大家有这方面的体验的你去体悟一下啊，你去看，你在电脑上你从网上打开电视节目看，你马上就有一种轻松的感觉。那么你要如果去聊天或者说你去看一些资料，你就会觉得非常紧张。因为什么呀？因为那个肌肉啊，要高度紧张保持你这个头的姿势不能动。你要如果说看一个活动画面的话，你这个头就没有必要保持那么高的精度，你看不到那么详细。但是你要看文本的话，就不行了，每一个字你都得看清楚。所以说你不由自主地，实际上就是肌肉高度紧张。高度紧张的肌肉是什么后果啊？那就是他消耗营养就多嘛。消耗营养多，你整体供应又不足，这个地方就成了一个灾区了。他就严重不足，严重不足以后也就是说失养了，失养以后出现各种病变，可以是各式各样的病变。多以像疼痛啊、像麻木啊、或拘急不适啊等等的吧，他就出现这种病变。

那么我们从这一条，从这个角度看过来，你再按着这个地方治，这就是浅层次的治病了。这个层次就太浅了。为什么啊？因为你比如说啊，就是刚才我们说的那个用手法治疗的，他给他用强力的动作一扭，扭了以后，实际上等于说他通过临床当中总结出了经验。这种扭法，这个力度，这个方向，他扭完了以后，他能改善这个地方，等于说他实际上就改善了他这个局部的血液循环。使他这个地方血液循环比以前流畅了，他相对说得到的营养就多了。那么潜台词是什么？潜台词是其他的地方得到的少了。因为你没有改善整体的机能，所以说其他的地方就得到的能量就少了。那么其他的地方得到的能量少了以后，后果是什么？他不一定什么时候，他要在别的地方再发生其他的病变。我就见过这样的病人，腰间盘突出找了一个好大夫，用手法一

扭，扭一次好了。那么几年以后，两个关节不行了，走路不行了。

说到这儿啊，那么你再看看经方治病。这一个桂枝加葛根汤照顾的面就相当多了。大家再去看看葛根汤吧，葛根汤不就是因为他有表实证，所以说加了一个麻黄嘛，里头还有一个完整的桂枝汤呢。大家再去看看桂枝汤的其他的证治，确实它有从某种程度上，如果说你有桂枝汤证的话，对这样的病人它确实有补虚的作用。确实能强化人体，整体的强化人体。

所以说那么如果说我们把问题讨论到这儿，我们再往下追究的话，问题就有点宽泛了，而且也有点严重了。你从这个角度再去看，中医里边很多的治疗办法，包括几乎西医里边所有的治疗办法，几乎都是这种理念，都存在这样的问题。这个呢我呢我想呢咱们也没有时间说的太多了。而且呢大家自己去感悟吧，你从临床当中，从这个学习的过程当中啊，你再去感悟，看看是不是这个样子。

大阳病下之后、其气上冲者、方用前法·可与桂枝汤、（注）若不上冲者·不可与之·（15）

胡希恕：这一段也挺有意思，太阳病啊，它是依法当发汗，吃下药是错误的，误治。那么，误治后这个变证是多端呐。如果这个患者呀，感觉有气上冲，从哪往上冲啊，从小腹往胸上冲。这是一种自觉症状，所以我们要问病人。这个时候啊，表未解，可与桂枝汤，和前面的服法一样，也要喝了桂枝汤之后，要喝一碗稀粥。

那么这个气上冲是怎么回事啊？这个我们就是要看以前太阳病是怎么的一种病了。这个太阳病我们开始讲了，这就是机体对外邪它要斗争，它想怎么的呢？我们方才还讲呢，《内经》上也是这样，邪气交争于骨肉嘛，想要把这个病邪呀从上半身，以发汗的这种作用解除到体表，没解出去，解除不了，限于自然的良能啊，他就发现太阳病的这种证候，脉浮，头项强痛而恶寒，就发现这种证候。那么这个

时候这个大夫呢，你得帮助机体驱除病邪就对了。你再治里以下法，机体这个机能啊，由里往外往上，想要发汗，这大夫给吃泻药了，这不正给生理机能一个相反的打击吗。

那么这时候就看这个患病的人体呀机能的强弱了，如果机能强，亢盛，它不但没使这病有变化，而反到给下药以回击，这个病人就感觉有气上冲，这是个神经的证候。那么如果不气上冲呢，这个机能就受不了下药的打击，那这个病就变了，就陷于里了，离开表了你就别给吃桂枝汤了。所以这个气上冲在这块儿的反映啊，正反映这个病体保持了原来的抗病的机制。所以中医这点的观察我认为是很宝贵的，永远是正邪交争。那么我们治病啊，把正与邪斗争的这个机制，给予相反的阻碍，这个病是要坏的。那么这个应发汗帮助机体解除疾病就对了，你吃泻药，正与这种机制一个相反的作用，那么机体反倒反抗这个，这说明它这个证像还没变，还是那个机制，所以还可以给桂枝汤。

为什么吃桂枝汤呢？这个也要注意，它本来太阳病，下之后，这没提自汗啊，为什么使桂枝汤呢？它这个下伤津液。桂枝汤，这个就看出来了，汗吐下这种治疗，这都是攻啊，都是治实证的办法呀，全足以亡津液、亡血液，所以经过这一种治疗而有表证，绝不能再发汗了，不能用麻黄汤了，必须用桂枝汤。为什么？桂枝汤，它是安中养液而来解除疾病的。所以凡是津液有所损伤之后，有表证，用桂枝汤，不能用麻黄汤，不管他有汗没汗。这个凡是太阳病，下之后而表不解，这还得使桂枝汤。表不解，有什么证候呢？这是一个，一种，他气上冲，那说明表没解。那么可以与桂枝汤，根据前边，还得喝稀粥的方法。“若不上冲者”，这个病就已经变成坏病了，那就随证治之了，你不能再给吃桂枝汤，不是说下后，就得吃桂枝汤，也不是的，得辨证。

李冠杰：这一条呢，《宋本》是这样的啊，后边是“方用前法；

若不上冲者，不可与之”。

这个条文里面呢，在《康平本》和《宋本》啊，差距就比较大。在《康平本》里面看呢，既有顶格的条文又有旁注又有嵌注，那么你看啊，“若不上冲者，不可与之”。这个部分内容呢，应该是叫，尽管它在条文最后啊，如果说在最后加个注呢，也可以把它叫做是附注。但是这个条文，其他的地方，有一些加在原文之间的，跟原文是一行下来，加在原文里边的，这个就应该叫嵌注。但是像这个，尽管是在原文的最后，但是实际上这也是嵌注内容。因为它是对这个条文的补充说明。要是附注，往往是另起一段的话，把他看作附注还是比较恰当的。而且这些注解，当时在校《康平本》的时候，这些注解啊，你很难把它分得很清楚，这些定义也不是说特别准确，也不是特别严谨。我查过一些资料。

我们看这个条文，这个“方用前法”四个字，在《康平本》里边呢，它的位置在哪呢？在“其气上冲者”，在这一句话的右侧，，这一句话的右侧的下半部分。所以说呢，我把它们重新排的时候，我把它排到了“其气上冲者”之后，按道理它应该排在这个地方。但是呢，要是按字面意思的话呢，它应该像《宋本》一样，应该在“可与桂枝汤”之后，按意思如果排的话。那么这儿呢，其实我们从这里，从《康平本》的这儿，我们也能看出好多信息。这个因为没有太大原则性的问题，我们就不去过多解释了，浪费时间，大家自己去感悟吧，仁者见仁，智者见智。

这一条我们也做个直译：本来是太阳病，本为太阳病，如果经泻下之后，患者仍有气上冲症状的，可以用桂枝汤治疗；如果已经没有气上冲的症状，则就不可再予桂枝汤治疗了。

凡太阳病，都应该用发汗的方法来治疗，这是经方里边的一个治疗原则。但是如果用泻下的方法治疗呢，这就等于误治了。所以说古人这个文字里边，他用字非常简洁，但是他背后的意思，要说的话很

多。你比如“太阳病下之后”，太阳病为什么下啊？本来不可下，那么为什么要下啊？实际上这背后的意思是说，这是误治了，错误地采用了泻下的方法。

那么泻下以后，你要看他用了泻药以后，再去看看病人会出现什么情况。你错误的治疗，绝对不会增强人体的抵抗力，这是肯定的，他对人体绝对是一种损耗。但是这个时候如果这个人体仍然表现为“气上冲”的症状，那么实际上这个意思就是要说这个人体啊，还有那个能力从表解除疾病的那么一种趋势，还有这种趋势，这个时候就应该顺应人体的这种能力，那么就应该用桂枝汤来治。

这儿他隐含着另一层意思，如果说他以前是一个麻黄汤证，假设说啊，前边说的是太阳病，太阳病本身就包括了表实证。如果说他是一个表实证，经过泻下以后，也应该用桂枝汤来治疗，这是经方的一个治疗原则。因为相对于麻黄汤来说，桂枝汤在解表的同时，它更适合身体内部比麻黄汤更虚弱的这么一种情况。那么泻下之后，人体就处在这么一种情况下，所以说呢，就应该用桂枝汤。而且这里说得也非常客观。

古人的这些文字，你得细抠，他用的是什么呀？让你用桂枝汤，但这却用了“可与”，那么这个“可与”就有商量的余地了。你有斟酌的余地。事实上，他后边有论述。就是说你要是如果说没有气上冲的情况，或者说你一再地误治，他没有表证了，那他就变成坏病了。那么有没有泻下以后，依然保持着明显的表证的症状，表证症状的那种情况，有啊，有这种情况。有这种情况下，你就用桂枝汤治就行了。

那么，要如果说变成坏病了，你就“随证治之”了，那你还得用别的办法治了。那么有没有介乎这两种之间呢？有，肯定有。那么有怎么办呢？诶，大家看看，那么你就得斟酌着看了。你比如说，他泻下了以后，他还老在下利，他还有一点点表证，那么恐怕气上冲的能力也不太明显，甚至接近没有了，但是他却有表证，也就是说，他还

有表的这一部分成分，桂枝人参汤不就是治疗这个的吗？

那么要如果说，这儿他说了一个“可与”，如果说现了其他方证，你就用其他的方子。那么要如果说桂枝汤不能完全覆盖的症状，你还可以加减嘛，只要是符合经方的理论体系就行了。

当然，这是程度比较深的啊，现在特别是初学，你一开始最好先不要加减，先去体悟经方的原方的方剂的作用。

那么，我们也能从这个条文里边还能另外看出一个意思，像加的这个旁注，这个旁注的“方用前法”这四个字，大家看看是不是有点多余啊？没有用处。所以说，你再往后看，当然我们前边已经讨论过，这个旁注本身是个很复杂的事，我们现在已经没有直接的证据了，你很难说他就是王叔和写的了，或者说他就是张仲景写的，或者说他是其他人写的。反正是那种顶格条文作者写的的可能性非常小，那么具体是谁写的，我们已经不知道了。但是从这以后这类的情况还很多，就从这个方剂的旁注的这四个字看，这个作者的水平很低，完全没必要加这四个字。干什么啊？桂枝汤在那写得明明白白的，完全没必要。恐怕是这里边也有一个文化，我们就说合情合理的客观地说，他有一个文化进步的特征。你看我们的文字，从那么古朴简洁逐渐地我们现在写文章相比，很啰嗦，非常啰嗦。但是啰嗦是什么呀？也不是说都啰嗦，他好多东西是因为我们现在书写方便了，我们会用更多的语言把他写准确了，写详细了。这要如果说从这个意义上说，他有他积极的一面。但是不管怎么说，你要是跟那个像我们再看看那个嵌注，这个嵌注就加得非常得精妙，“若不上冲者，不可与之”。这又给你进一步地作了一个说明。相对地说，尽管说这一句话似乎让人感觉到也是有点，你没有它，原文里边也应该能品出这个意思。但是，他又进一步地肯定了一下。这个嵌注的积极方面的意思要比那四个字要有价值得多。大家可以去比较。

大阳病三日、已发汗、若吐、若下、若温针、仍不解者、此为坏病、（注）桂枝不中与之也・观其脉证・知犯何逆。随证治之・（16）

桂枝本为解肌、若其人脉浮紧、发热汗不出者、不可与之也、常须识此勿令误也、（16）

胡希恕：太阳病三日，已发汗，若吐、若下、若温针，仍不解者，此为坏病，桂枝不中与之也。观其脉证，知犯何逆，随证治之”。到这是一段，底下这个是另一段。“桂枝本为解肌”呀，应该另一段，这个搁一段是错了，成无己本呀就是分为两段。

那么这段说的呀，太阳病将三天，经过发汗，发汗是对的，太阳病当发汗嘛，发汗没好，如果表不解，你还得想法子服桂枝汤。那么这个大夫啊，就是三天的功夫，发汗他还没好，他就是若吐若下若温针，乱来一阵，这些治疗都是错误的，所以这个病仍不解，这个病不会好的，此为坏病。这个不解呀，就是治坏之病呀，他这么样子又吐又下又温针，这个病决不会再在表了，它是逆治而成的坏病。

这一段它也跟上边有关系，说“下之后，其气上冲者，可与桂枝汤”，但不能说是你经过治完了这个病不解，就吃桂枝汤，这也是不对的，他这是仅举一个例子。这都在桂枝汤的基础上，而来论述的，哪个应该用，哪个不应该用。如果治坏的病了，那可就不能用了，所以“此为坏病，桂枝不中与之也”，那桂枝（汤）不是一个万能的药啊。那得怎么办呢？详审其脉症，那么他这个书啊，就是辨脉辨证，看其结果“知犯何逆”，这个“知犯何逆”面很广，不是光问他是怎么治坏的，那个是可以问的，不是不可以问的，主要的还是在这个结果，他是津液亡失太厉害的变成里虚证啊，或者由于这种错误而邪入内呀，是发生陷胸汤证了，是发生阳明证了，或者发生阴寒重证，这都不一定的，这都是治逆的结果，“知犯何逆”，让你考察这些东西，随证治之，这是中医辨证的主要精神，这句话不要把它轻易放过了。

中医治病就是随证治之，不是你拿脑瓜想。那么有什么证，你就应该怎么治，现桂枝汤证用桂枝汤，现承气汤证用承气汤，这叫随证治之，随所现之证而来治疗，不是你那么想，那不是中医辨证，这很重要这句话，它是一贯全书这句话。所以刚才讲这个桂枝汤，在临床上你遇到桂枝汤（证），这个证候合适，你就用你的，什么病都是，随证治之嘛。

底下，这是又一段了，“桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与之也。常须识此，勿令误也”，这也是围绕着桂枝汤来论说的。他说还有一个同是太阳病，到这一点啊，他说的是桂枝汤的医疗作用了，那么桂枝汤本为解肌而设，什么叫做解肌呀？中风，头一段我就给讲了，这个病邪深，就是这个精气不足以驱邪，他反倒出汗了，可是这个邪呀，趁着出汗之虚，而入肌肉之内啊，它离开表皮了，表皮虚了，这个病整个在肌肉这个阶段，桂枝汤就是解肌肉那块儿的不和，去那块儿的病，怎么去呀？就头前讲的这个，安中养液，增强精气。这不虚呀，邪在这儿呆不住，这个精气充实于肌肉了，再一出汗，邪就跑了，它在那儿呆不住了。它是解肌，主要的目的就是咱们方才讲的，它是安中养液，充实精气，这个力量足以驱邪了，那么再一汗，邪就走了，所谓之解肌。与专门来发表的，让他出汗的那种方剂，麻黄汤，是大有区别，是不同的。

所以他底下接着，“若脉浮紧”，咱们说那个阳浮阴弱啊，在桂枝汤，浮之中，按着没力量。脉浮而紧，这个脉呀紧聚有力，这个紧啊，我上头说了，就脉的宽度上来看的，它这个脉道是紧束有力，那里头充血的情形是相当严重了，就像一个胶皮管子，你灌得溜紧，就是打气它紧，咱们都骑自行车呀，自行车轱辘气打得蹦蹦的，拿手一按紧啊，你把气放了一半，一按就是缓弱，这个紧说明里头血液充实。“发热汗不出”啊，它也像桂枝汤证发热，但是呢就是汗不得出，汗不出不是说不出汗，是汗不得出，他这个精气充实在体表，所以血管

里充满液体，它就是皮表不开，出不来汗，一出汗马上就能好，他这个精气不是虚，一点都不虚，反倒实，由于这个实，造成汗不出。这时再给吃桂枝汤，那了不得了，桂枝汤它是增益体液的，就是精气呀，这就变成实实之祸了。本来就实，你还让他增加津液，增加精气，那就实上加实了，这个在《内经》上就是“实实”嘛，实证，又当虚证治，再让它实，这就是实实之弊也！这个病只能够是更加恶化，而不会好。所以他就再三叮咛，“常须识此，勿令误也”。这都是这个感冒，外感，该要用麻黄汤的用桂枝汤不行，反过来呢，应该用桂枝汤的用麻黄汤也不行，后边就要讲了。那么桂枝汤这个作用啊，不是单纯的发汗药，“本为解肌”，所以到这个地方把这个医疗作用啊，他才点出来。那么解肌的方法呢，他就要安中养液，增强精气，而来达到解肌的目的，那与单独发汗的药是不同的。

李冠杰：第 16 条条文：“太阳病三日，已发汗，若吐、若下、若温针，仍不解者，此为坏病”。下边是嵌注：“桂枝不中与之也。观其脉证，知犯何逆，随证治之”。后边的内容呢，在《康平本》里边另起一段，但是在《宋本》里边它是一条，我们就把它放在这儿了。那么“桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与之也，长须识此，勿令误也”。那么这一条呢，如果说我们看一看《康平本》，大家看啊，《康平本》这个段落的划分呢，要合理一些。而且呢，这里边有一部分是嵌注的内容，可以说明很多问题。

那么我们下边呢，再详细地看一看。但是我们刚才说了一个问题，我们先从一个与版本有关的，我们从这一条能看出一个很重要的问题。就是我们刚才前边那一条，咱不是说了一个是日本人在《宋本》的基础上，按照自己的那个某种目的，把它改写成那个样子。大家再来看看这一点，这一条要如果说后人改写的話，这就不可思议了，大家想想，谁能想到，能把《宋本》的样式把它改成这样？你要如果说是“桂枝本为解肌”之后这一部分内容，是另外一个段落。这个呢，

让人感觉，如果说你要是细抠内容的话，能够感觉出来这是一个，它跟前边内容呢，不是直接联系的，不应该是一段条文，这个还可以理解。但是为什么要把它跟前边这个“太阳三日”这些个内容，要把它分成两个作者做的内容呢？有什么依据吗？有什么目的吗？这解释不通的。特别是像“桂枝不中与之也”，后边这个，也就说这个嵌注。这个嵌注内容咱们现在这是个脍炙人口，咱们学经方的人都知道这个。那么要如果说，你手里边有一个《宋本》的话，谁能想到就把这几句话把它改成一个嵌注，毫无依据也毫无目的。

所以说，那种说这个《康平本》是在《宋本》的基础也好，或者其他的版本基础也好，出于某种学术目的，人为的改造过来的，这是不可能的。像这些啊，还有商量的余地的，这个还有商量的。后边还有一些，还有的条文里边，有缺字符号，而且在《宋本》里边没有这个缺字符号，那么谁会想到在这个地方加一个缺字符号？大家有兴趣的话你去看一看，这都是不可能的事。所以说，那种说法太牵强。

那么如果说是反过来说，说《宋本》是在《康平本》的基础上，把这些旁注、嵌注和这些不同排版格式这些条文全都篡入原文，是完全合情合理。你去越分析，它越合情合理。而且呢，从这里边能分析出好多，这个尽管说没有明确的依据，但非常有意思，而且能够让你都（从）这本书的当时的背景了解很多的这么一个，了解更多信息的这么一些东西。那么我们这呢，就不去做太多地讨论了。

我们做直译：患太阳病已有三天左右，已经经过发汗，或者是涌吐，或者是泻下，或者是温针等方法治疗过，但是病证仍未解除的，这就是坏病了。后边是嵌注内容啊：这种情况下就不能再以桂枝汤治疗了，应该进一步观察其疾病反应，弄清疾病的真正原因，然后根据疾病反应的证候，采取相应的治疗方法。

那么这儿呢，因为这个条文呢，相对说比较重要。所以说咱们这个直译呢，也比较繁琐一些，就说尽量得能够更确切地把它原意呢，

给表达出来。

下边一段呢，桂枝汤的主要功能是治疗表虚证，如果患者表现为脉浮紧，发热汗不出的，不可用本方治疗，要时常记住这一原则，切勿发生错误。

那么这儿“太阳病三日”，这个“三日”实际上就是一个约略数，不是一个准确的日期。但是它有意思了，那么为什么要都说一个“三日”呢？就是说病程已经有好几天了，有那么三天四天的时间了。说明什么？说明这个表证啊，本身就相对地说就比较重一些。你要是轻的话，随便吃点什么发汗的药，或者说是，甚至他有可能自己就会（痊愈）。

另外呢这儿说的“太阳病”，当然也包括表实证和表虚证这么两种。

这儿的“发汗”，这不“已发汗”嘛，那么已经发过汗。为什么？我们刚才说这个“太阳病”里边，我们应该体悟到它既包括表实证，又包括表虚证。如果说要是表虚证的话，这儿的在经方里边说的“发汗”，常常是单指麻黄汤而言。那么这儿的发汗，就是一种误治。那么要如果说是表实证的话呢，当然也不排除是正治的这种可能性。但是要结合后边的文字说呢，这是两种不同的论述方向。那么一个说是你误治了，误治本身就有可能产生变证，就有可能造成坏病；另外一个说呢，你虽然说是正治，但是你后边可能因为病重，发一次汗没好，发现病不好，又用了吐又用了下的办法，一系列的误治，这些呢，都可能造成后边的不良后果。那么这儿的你像“仍不解者”，这意思就是说这是一种，表面看啊，他这个病没有好。你一大堆的误治能治好吗？但是你要如果说真要是懂经方理论的话，你会知道这句话不是单纯的这个意思，里边还有另外的意思。我这个地方讨论的是什么？讨论的你经过了误治以后没有治好的，“仍不解者”，不仅仅是表不解了，还应该说是出现了其他的变证了。是这个意思。为什么这么说呢？

误治还有好了的吗？有。后边第 58 条就是，经过吐也好、下也好，“阴阳自和者，必自愈”，那就不需要治了，不要治。像经方这些东西以后我们还会讲，这些东西在传统医学和现代医学里边，这都是不可思议的，根本没有这种理念，误治了以后，但这都是来自于临床。有时候他确实经过了误治以后，人就是各种症状都没了，你摸摸脉还是个平脉，先不要治。

但是说误治了以后能增强人体的抵抗力，能增加人的能量吗？不能。那么怎么会好了的呢？咱们以后还会再讨论。我们这儿讨论的是经过误治以后没有好的那种，这种常见的症状，大多数的情况。咱们如果说我们记着这儿，当我们以后再学第 58 条的时候，那是说的一种特殊情况。不是说这个人得了表证以后，你泻下以后，你吃泻药就能好了，不是。但是偶尔也有吃了泻药以后也有症状消失了，消失了就消失了，不要管了，这是经方的理念，这是经方理论里边的内涵，我们应该了解。

“此为坏病”，这个“此为坏病”大家看这个后边的嵌注，就跟前边我们那一条的嵌注就异曲同工。实际上原文里边的“此为坏病”就到此为止了。言外之意，古人那个时候，就是说张仲景之前那个时候那些人，特别是我们现在看，特别是《汤液经》的作者写东西太过精炼了。其实大家看“此为坏病”到这儿已经把问题说得很清楚了，坏病你就按照坏病来治不就完了嘛，言外之意不就是这个意思嘛。但是后边我们可以这么说，大概是张仲景又对它进行了一个补充，补充了以后就是说这种情况桂枝汤就不能用了。你再进一步去看看到底发生了什么样的坏病，是什么病按什么办法来治，具体的治疗办法后边有，就是这么一个意思。

“观其脉证，知犯何逆，随证治之”。这整个，这是经方理论里边一个比较精的地方，这是一个亮点。正因为这一点，可能大家都了解得已经很多了，我们就不再过多地去解释了。相对地说对前文起到

了一个正确的诠释，而且说得更具体、更详细、也更准确。就是说我们治病就是是四诊：脉和证，四诊基本都包括了。

“知犯何逆”就这两个方面了都包括了：一个是病因，一个是病理。什么原因造成了？是吃错了药，还是病重。

“随证治之”这是大的原则，不管你是什么样的病理，是什么样的原因，我们都要采取方证相应的原则来治疗。其实这个很简单，你用脏腑辨证是不行的，你不能去对着脏腑，你得对着证，经方治的是证。

下边一段：“桂枝本为解肌…”，这一段在《康平本》里边是降一字格的，也就是说比顶格的条文降了一个字，在我整理的是宋体加粗的。我们从它本身这个条文的理解上不会有太大的偏差，就比较容易理解。但是这儿“桂枝本为解肌”，我们可以把这条条文理解成出自张仲景之手。“桂枝本为解肌”，是张仲景对医理、病理的一个诠释，这是他的一个解释。而且我们纵观全书再去看其他的地方，你会发现张仲景在理解《汤液经》的基础上，他做了这样的解释，我们有理由相信《汤液经》的作者未必不懂得这些道理，只是他没有说得这么明确。但是张仲景又理解了，而且在当时来说，那个时候说是最现代的一些理念理解了以后，把它又升华到理论的高度，做了进一步的解释。这在小柴胡汤证条文里边说得更明显，像那个“血弱气尽腠理开”，那一条我们学习的时候再讨论，那个就很明显了。而且那个条文在《康平本》里边也就是说是出在张仲景之手。我们明显看张仲景的理论是非常高的，而且他跟王叔和的那些解释，也就是说降两字格的那些条文，不仅仅是一个写作水平的问题，在理论上也有质的区别。

这儿“若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与之也”。实际上这就是一个表实证，这个没必要做过多的解释，他就是想说这就是一个表实证。那么如果说是一个表实证的话，你就不应该用桂枝汤来治疗。

大家看整个这几段都是在说桂枝汤应用过程中的，从桂枝汤的应用过程当中衍生出来的一些具体问题。而且都是一些很重要的方面。这一条等于跟大家说了一个桂枝汤的禁忌，严格来说整个内容跟上半段没有直接的关系。后边“常须识此勿令误也”，这就是要求大家把它当做一个治疗原则来看。

若酒客病、不可与桂枝汤、得汤则呕、以酒客不喜甘故也、（17）

胡希恕：这个酒客病啊，就是病酒，病酒的人。这个过饮的人常得酒病啊，我们那边就有老喝酒就得酒毒。酒毒，这个人就大便不通了，那么人也是汗出。那么这一类的病，它是因为酒这个东西蕴湿蕴热，它由里往外蒸，也出汗，你这个你拿它当桂枝证可不行，所以病酒的人，他是老喝酒呀是吧，他是蕴湿蕴热而汗出，这个它是在里呀，桂枝汤它是解热，它是解外热，里热千万不能用。

“得之则呕”，里头有热，这个病酒的人他喜清凉啊，他里头有热嘛，有湿有热，而不喜甘温。这个桂枝汤是甘温药啊，甘温除热，除表热除外热。而且还得精气虚，精气不虚用着都不行。要用它呢，怎么样子，反助其热，壅逆于上啊，一定要呕的，这个甘药多壅，壅者往上壅啊，这再加上温，里头还有热，那以热治热，非吐不可。所以这个桂枝汤啊，应该戒之用这个地方，第一个提出来，就同是表证，脉浮紧，无汗，那么汗不出这种发热，那是表实证，那是麻黄汤证，不能用，虽然在表有热也不能用，因为这个脉浮紧而无汗，无汗不能用。这一节呢，虽然汗出，里热也不能用，他搁个酒客病，来说里热也不能用。你要用了吧，用了非吐不可。所以这个桂枝，我们这个里热的病，你千万不要用，所以他头前明说嘛，“太阳病，头痛，发热，汗出，恶风者，桂枝汤主之”，必须有个太阳病在那儿，这个可是一个主要条件。里热不行，里热有汗也是不行，这就说明咱们要是平时

看病啊，也不能片面看问题。哎呀！说一出汗就是精气虚，看着出汗了就用桂枝汤，这可不行啊，那可是出错误的，这必须要全面观察，第一个确定它是太阳病，太阳病发热汗出，那你可以用桂枝汤。没有，不是太阳病，里热的问题，那用它坏了，一定要呕的。

李冠杰：这个条文在《康平本》里是降两字格排版的条文，出自王叔和之手。这个《康平本》和《宋本》有一字之差，差在哪呢？就差在“得汤”，《康平本》是“得汤则呕”，《宋本》是“得之则呕”，实际上等于说是一样吧。

这个条文用我们今天的话说，大致是这么一个意思：平时嗜酒的人，患病后不能服用桂枝汤，服用后则会出现呕吐，这是由于长期饮酒的人不适应甜味的缘故。

我们也把这个条文解读一下：

首先说这儿应该怎么去理解这个“酒客”。所谓“酒客”就是指长期、经常饮酒的人，就是长期嗜酒的这种人。如果偶尔喝上几次的，这不能算作酒客。那么为什么酒客就不能喝桂枝汤？这说得很明确。我们客观地看待这个条文的话，应该说一般长期饮酒的人，他容易产生里热，这个特别是我们做中医的感觉是非常明显的。因为不懂中医的人在这方面没有这个概念，他有时候里热重了以后，自己也会说我最近上火，火挺大。但是很少有人跟喝酒会联系起来。这个酒如果站在我们中医的角度来看，应该是一个大热的，在我们的饮品里算一个比较热的饮料，严格地说算是一种毒药了，它容易产生里热。其实我们前边学桂枝汤的时候已经说过了，桂枝汤的本身是一个甘温剂，如果有里热的人是禁用桂枝汤的，这是一个常识。这一条它要说的就是这么一个意思，我们今天呢应该这么去理解。

后边的内容它又做了一个解释说“酒客不喜甘”，这就有点牵强了，所以说这个条文我们还要进一步地做一个讨论。我们讨论这个条文的话，如果有的人看过有关这一条的其他注家的一些解释，就知道

这条在学术界本身就有争论。甚至可以追溯到《康平本》回到我国之前，有一些著作就对这个条文提出了异议。但是看古人的东西我们应该客观地看。这个条文它一定是作者（如果简单地把他说成王叔和）在临床当中，他应该是在别人那儿得知了这样的经验，但是他的说法未免有一些片面，说的过于机械，因为把这个事绝对化了。要是按这个条文的字面意思说，经常喝酒的人就是不能喝桂枝汤，而且把道理也给说清了，经常喝酒的人它不适应这个甘甜的药。

实际临床当中，之所以后世的注家对这个条文提出了异议，就是因为临床当中确实有经常喝酒的人得了桂枝汤证，服了桂枝汤不至于像条文说的每个人都会吐。所以说，这个条文只是说的一部分现象，不是一个全面的现象，而且把它绝对化了。这个条文对我们今天实际的临床意义不是很大，我们知道它的意思就行了。

实际上我们前边已经说过了，有里热的人肯定不能单独喝桂枝汤。实际上跟这个是不是“不喜甘”也不一定有对应的关系，就是说有里热这个桂枝汤就不合适，在辨证上就等于说不对证。

但是我们今天对这个条文要多说几句，为什么啊？因为以后还有众多的类似条文，所以说从现在就提起警惕。这应该是降两字格排版条文的作者一贯的风格，在很多条文当中都有失于片面的情况，不仅仅是一个条文的问题。还有比如以脉定证，这在中医里是一种不客观的倾向，仅仅用脉来确定疾病的性质，严格地说不符合中医的理论，特别是不符合经方的理论。这一条我们能明白这个问题，也算我们学这一条应该受益的就有了。一点呢，就是有里热的人再一次强调一下，不能单独服用桂枝汤。第二点呢，就是对《伤寒论》里边的条文应该客观地来看。

喘家、作桂枝汤、加厚朴杏子佳、^{（18）}又服桂枝汤吐者、

其后必吐脓血也、（19）

胡希恕：喘家，平时就有喘的人叫喘家。那么他患了桂枝汤证，你打算也给他作桂枝汤服之啊，可他平时就喘，当然他得外感还是喘，这你对这个喘也得照顾，所以用桂枝汤那是必然的了，你还要加厚朴杏子才好呢。

你方子还是得加减变化呀，他这也举个例子，他比方说吧这个喘家，那么他外感了，是桂枝汤证，就像我们头前那个头痛、发热、汗出、恶风、脉缓，这类的情况，肯定是桂枝汤证了，但他喘，那再加厚朴、杏子较为好。这是警戒。里热吃桂枝汤，一定吐。这个发汗啊，伤津液，里热反倒更助热。你们看这个《金匱要略肺痿肺癰》那节就知道了，他说热在上焦为肺痿，这个肺痿怎么来的，就是热在上焦。那么底下他又说了，肺痿之病从何得之？他说头一个从发汗，或从发汗，或从消渴，或从快药下之啊，都是伤津液。里热，你再助其热，再使他伤其津液，这个没有不伤害肺的，这个肺为嫩脏，也容易伤，而且热伤血脉，那么气血凝滞，它就要为痈脓之变，这个你们回头看看那个《金匱要略肺痿肺癰》那一篇就知道了。这个就是在这儿，内热的，你要拿那个甘温药，让它往上呢，壅于上，准伤肺。这不是说吃一回，那么如果他吐了，说明这个热往上壅的相当严重了。那么如果这个热久久不去，其后必吐脓血，所以这个应该戒甚啊，这个危害呀相当严重啊。这个不能治里热，里热攻表，这根本就不行的，况且桂枝这种甘温药更不行。

李冠杰：“喘家，作桂枝汤，加厚朴杏子佳”。这是第 18 条，后边第 19 条：“又服桂枝汤吐者，其后必吐脓血也”。这个条文在《康平本》里是同一条，《宋本》里把它给拆成两条了，这个也没有太大的区别。其中有一字之差，第 19 条的第一个字，《康平本》是“又”，《宋本》改成了“凡”，从字面上看也没有大的区别。

但是明显能看出，这个“又”在这个地方，是另一个意思，是说

另外“服桂枝汤吐的人，其后必吐脓血也”。“凡”字一下就把这个事给绝对了，其实从文字上来看，本身作者就想说这个意思，绝对化的，也没有什么原则性的错误。这一条在《康平本》里边是降一字格的内容，我们就把它认为是张仲景写的。

第18条有一个读法的问题，古代的文字没有标点，而且条文的文字又特别简，所以逗号、句号比较多。这个逗号是标在“喘家”之后，还是标在“作”之后，这是两种不同的标法。还有“杏子”之后，还标不标一个逗号？我想之所以我们这次把《康平本》重新校对，就最大限度地保持《康平本》的原貌，没有对标点进行改动，基本维持了原来的样子。因为标点符号本身就是后世的注家给加的，对我们解读起到一定的作用，但是也反映了当时标标点的这个人，如果我们每一个人读了以后都去标，当然标完了以后，你可以自己当作学习的资料用。我的观点就是能见到的旧貌越早越好，最大限度地尊重它的旧貌。这个《康平本》如果谁有这个能力，把我们现在整理的WORD版的，整理成跟《康平本》一样的版式，竖排版的，你去看这个版本，越品里边越有味道。好像你就看见这是一条一条的竹简，竹简上边别人在加东西，就是那样的感觉。

怎么标记不是很重要，重要的是我们怎么理解这个条文。实际上这个条文从字面上理解不是特别难，但是我的感觉恐怕当时王叔和在得到这个条文的时候，是不是简上有残缺什么的，现在不敢说，总是让人感觉意思表达不是那么完整。

根据我们现在现有的情况解读一下：平时素有喘疾的人，如果发生桂枝汤证，则以在桂枝汤中加厚朴杏子疗效更好。另外，如果服桂枝汤出现呕吐的，以后则会出现吐脓血的情况。这个条文用白话说出来，意思相对还比较完整一些。

这个条文论述的是一种阳性的表虚证，在表虚证的同时，又伴有咳喘症状的一种病理状态。条文中的“喘家”，和我们说的“酒客”，

是一个道理。“喘家”就是说他有喘这个病，已经不是一天两天了，临时感冒引发的咳嗽或者是哮喘之类的不能算“喘家”，“喘家”是早就有这个陈旧的病，这样的人如果患了表证，那么他的喘肯定会诱发发作，或者他以前就有点喘，他会更重一些。这一条说的是一个很窄的一部分患者的情况，因为患了太阳中风证，也就是说他患了桂枝汤证，同时他又有喘，这个喘不是桂枝汤所能治疗的范畴，它超出了桂枝汤所治疗的范畴。从这个条文，我们可以理解到，当时作者写这个就有这方面倾向，患者的基础是一个桂枝汤证的底子，同时又有喘证，就不要把它再理解成其他的方证了，比如麻杏石甘汤证，也有喘，汗出而喘嘛，身无大热。只要辨证正确，认为它确确实实是一个桂枝汤证，但是又伴有喘，你在这个基础上，在桂枝汤里边加上厚朴杏子，就可以治疗。我们从这也能体悟出来，这个地方是张仲景自己的临床经验的总结。

这个方剂是桂枝汤的原方，加了厚朴二两、杏仁五十个。这个方剂在《康平本》第19条之后没有这个方剂，包括方后注什么的都没有。

厚朴杏子这两味都是温性的药，厚朴在这个方剂里面主要是用来行气，杏子就是杏仁，它可以定喘。这个方剂整体偏温，它对应的应该要比桂枝汤偏于寒，有的注家把它解释成治寒喘的方剂，这只是站在寒热的角度去解释它。比如小青龙汤是治寒喘，那也是有里寒哪，但是小青龙汤跟它就不一样，如果有饮证这个方剂还概括不了。这个方剂主要就是一个阳性表虚证又比桂枝汤略偏于里寒，同时伴有咳喘这样的症状。

从临床实际运用看，这个方剂临床当中表现出来的症状主要有这么几种：一个是发热，恶风寒，汗出，咳嗽或者气喘、或者是短气，痰呢呈清稀白色，这儿又看出它是偏于里寒了。舌像有舌淡、苔白，脉或浮或缓或弱，因为它是桂枝汤的底子嘛，脉里边也不会相差得太

远。

它所治疗的现代病根据临床统计大致有这么几种：一个是感冒，一个是急慢性的支气管哮喘、过敏性哮喘、慢性支气管炎、病毒性的肺炎、过敏性的鼻炎、荨麻疹等。

这个方剂涉及的疾病和方证呢相对单纯，就不去详细说了。

通过学习这一条，我们应该想到更多的或者体悟到更多的问题。这一条实际上又是一个桂枝汤加减的示范，关于桂枝汤加减的示范我们讲桂枝加葛根汤的时候已经说的很清楚了，这一条是在桂枝汤的基础上又出现了咳喘了，而且还不能是偏热的。这是一个问题。

另一个问题，为了不至于让大家出现偏差，这本来是第 43 条的，我们现在把它拿上来，这个方剂应该和麻杏石甘汤做一个严格的鉴别，很着重的强调过这一点。在麻杏石甘汤条文里边就有“不可更行桂枝汤”，实际上指的就是桂枝加厚朴杏子汤。

我们在这儿学习的，没有哪个人是第一次学《伤寒》，大家回忆一下麻杏石甘汤，它的疾病反应症状和桂枝加厚朴杏子汤几乎是一样的，“汗出而喘，身无大热”，这个都是通用的。桂枝加厚朴杏子汤也有可能有发烧的情况，它们都表现为比较明显的感冒症状，在临床当中，都有汗出，都有喘，非常接近。我们应该去怎么鉴别呢？一个很重要的鉴别点就是一个是偏于里寒，一个是严重的里热。麻杏石甘汤的汗出不是一个表虚的问题，它要是真正的表虚也用不到麻黄了，它是因为里热太重，需要用出汗的方式把身体里边的热量散发出来。

单纯从汗的角度说，麻杏石甘汤的汗比较粘稠、粘手，人感觉身上出了汗以后很黏，味道也比较重。道理很简单，它是有里热，这是从里边发出来的汗，里热本身就是五脏六腑的机能亢奋，所谓亢奋就跟机器转速高，是以排泄物就更多，随着汗出来的代谢物也就多，所以说它比较粘稠一些。但是桂枝加厚朴杏子汤的汗相对地就没有那么凶，也没有那么粘稠，相比较要清一些。

实际上里热和里寒的还有其他很多的指征：比如脉象，以桂枝汤为基础的这种脉象它都会缓、弱，它有弱的这一面，但是麻杏石甘汤的脉常常是偏于洪大，当然也不绝对，它也不会浮紧，到不了浮紧那种程度，它有汗出嘛。因为它有里热，会比较滑数。从舌苔上看，常常舌质比较红，苔会黄，或者白黄相间，人也会表现得比较烦躁一些。它们鉴别点其实还是很多的。

古人一直在强调这个问题，后世的医家也一直在强调，因为实际临床当中也有可能用错了。怎么能减少用错的这种机会呢？告诉大家，你就踏踏实实地去把经方的辨证体系掌握好。表证、半表半里证、里证、水证、血证、气证，包括阴阳、寒热、虚实，这些因素怎么去判断？在你辨证的过程当中，能不能想到这些因素。比如在临床当中有个病人，在给他治疗的过程当中，你怀疑他是桂枝加厚朴杏子汤，你是不是可以想到再找一找有没有里热的特征，如果能想到这一点，你基本不会错了。但是临床当中不是这么简单。

这个方剂我曾经用错过。大概是前年，一个肺结核的病人，这个病人用了小柴胡汤合上小陷胸汤再加上生地麦冬，各种症状都有所减轻，而且里热比他初服药的时候明显地减轻，到后来我让他服桂枝加厚朴杏子汤的这一次，已经很难发现他有里热，脉象也不是那么滑那么数，大概稍滑一点但是不偏数；从舌像上看各方面看，没有明显的热像。但是这次来的主诉就是这段时间感觉气短又有点咳嗽，你看这不正好符合这个条文吗？他又是一个 20 多年的肺结核，他不是“喘家”吗？标准的喘家，而且脉也有点浮缓的样子，到处都觉得比较合适，我就给了他，我也觉得恐怕给他桂枝加厚朴杏子汤有点牵强。这有时候看病，等时间长了以后，大家都会有这种感觉，有时候是一种模糊的概念，不是说特别精确。他说：“这次药我好像觉得疗效不明显，好像咳喘吃了以后，还是那个样子，反而觉得不太舒服”。他跟我一说这个，下边的事就很简单了，基本就可以不假思索地改成麻杏

石甘汤，给他的量非常少，就是三四次的量。吃完就非常轻了，后来又改成小柴胡剂，吃了几天，慢慢基本上就很轻了。这一次对我来说，触动是比较深的，因为你找不到里寒的证据，你要用它有时候都得再仔细一些。

第 19 条，就是这一段的后半段：“又服桂枝汤吐者，其后必吐脓血也”。这一条我们可以把它认识成是张仲景的临床经验，张仲景的这个临床经验相对地说比较客观一些。

这里边有一个问题，“其后必吐脓血”这个“必”字，我们把它理解成“可能”或者“可能性比较大”更客观一些。这可不是给张仲景打圆场，后边有，像葛根汤那两条，就有一个“必自下利”，实际上很多葛根汤证没有下利的症状。所以古人用这个字，有时候不是我们今天理解的这个意思。这是一个什么样的情况呢？是指的一种本来有里热，如果服了桂枝汤以后，热往上涌，造成吐，这是一个很严重地用错桂枝汤的情况。如果一再地误让他服桂枝汤的话，他里热越来越重，很多治喘的方剂都明显地偏热或偏寒，麻杏石甘汤是一个典型的去热的药，大青龙汤也是一个典型的去热的药，理中汤也有治喘的机会，这是明显的热药。我们从这一类的方剂（还有很多）能得到一个什么体会呢？古人也看到这一点，说“肺为娇脏”，肺对寒热比较敏感，实际上也不仅仅是寒热的问题，如果它本身停饮的话，对它影响也非常大，它是每时每刻都要工作，它表现也比较简单，人体过于偏寒或者过于偏热，破坏了肺脏正常的工作环境它就受不了，如果再严重，特别是热的厉害了，血液的循环也会比较快，所谓“血热妄行”，一些浅表的血管会承受不了而破裂，导致出血。感染了还会出现化脓，发炎了严重了就会化脓了，这个时候就会“吐脓血”。这个实际上在今天也能见得到。

这一条里边，我们应该体会的是它的一个病理问题。我们今天在临床当中，遇到这种情况的机会已经很少了，因为我们今天身边的病

人，一个是不至于把病拖到这么严重的程度；再一个今天可不缺寒药，中医里边很多的人喜欢用寒药，而且现在西医里边用的液体，大部分都是偏寒性的。所以说我们很少能见到人热到这种程度的。

太阳病、发汗遂漏不止、其人恶风、小便难、四肢微急、难以屈伸者、桂枝加附子汤主之、（20）

桂枝三两去皮 芍药三两 甘草三两炙 生姜三两切 大枣十二枚擘 附子一枚炮去皮破八片

右六味、以水七升、煮取三升、去滓、温服一升、（注）

本云桂枝汤·今加附子·（例）将息如前法、

胡希恕：这个与“桂枝本为解肌”那节正是相反的，那个是桂枝汤不能用于麻黄汤证，“脉浮紧，发热汗不出”那个麻黄汤证。这个呢，它是桂枝汤证误用了麻黄汤，它这里含义是这样的，它这个书上倒没明写啊，它是太阳病桂枝汤证，而用麻黄汤发其汗，遂漏不止。

怎么知道它是这个意思，就从一个“遂”字，这个“遂”字是一个褒贬组词法，古人用字他净在字上琢磨，“遂”发汗“遂”就汗漏不止，这个发汗是错误的呀。太阳病不应该发汗吗，但桂枝证用麻黄汤发汗是错误的，所以发汗“遂”就而汗漏不止，大汗亡阳。“其人恶风”，这个恶风就跟头前那个，“病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也”。光恶风寒了，他不发热，这就说是现阴证了，表当然也没解，大汗淋漓，病必不除。由于津液丧失太多，“小便难”。这个体液大量亡失，小便没有，所以说“小便难，四肢微急，难以屈伸”，四肢微有些拘急，就是痉挛。而屈伸费劲，难以屈伸，就是弯回来，伸出去，一曲一伸嘛，这都是由于津液丧失太多了，组织枯燥才有这个情况，这个肌肉马上就有拘挛这种情况。

这就由于这个病发汗过了，应该用桂枝汤，用了麻黄汤了，虚极

就变成阴证了。那么这个汗多体温下降的当然也是多了，所以亡津液同时也能亡阳。那么这个时候用桂枝汤就不行，得加附子。附子这个药啊，是个辛温，是个热药，有亢奋作用，同时这个药在临床上体会，它能够复兴这个代谢机能。是生物都老在新陈代谢，这种机能要是沉衰，附子很有恢复他的力量。如果这种机能沉衰，反映在里，就说下利清谷，四肢逆厥，反映于里，你要用附子配合干姜这个药，四逆汤、通脉四逆汤都是。那么如果这种沉衰的机能反映于表，这就是反映于外表，你就用附子配伍麻黄桂枝这类的药。如少阴病，后来要讲了，麻黄附子细辛汤，也同太阳病一样，该发汗也得用麻黄，该解肌也得用桂枝，这个法度，这里也是。这个汗漏不止还直门出汗，这个发汗是不行了，也得解肌。但得解肌因这么样子虚，而现阴寒的状态，你使用桂枝汤是不行了，非用附子，大力附子。这个吃下去，既能够达到解表的作用，同时这种沉衰机能也能恢复。所以附子这个药啊，有这些作用。那么这个可见也是少阴病范围，但是少阴病里头，（音频缺失），也就是桂枝汤证，而现阴虚证（此处指阴证虚证）的话，加附子。

阴虚证表证阴虚还是一种少阴，这个表证有两种：一种是太阳，表阳证；一种是少阴，表阴证。那么这个桂枝加附子呢？就是桂枝证而陷于阴证，就是少阴病现桂枝汤证，就是这么一个情形。那你光用桂枝汤是不行的，他是一味恶寒而不发热，当然也怕风。他也出汗，出汗出的更凶了。

那么我们来应用呢，比方说少阴病，他有自汗，脉微细，但欲寐，这些情况，那你不能用麻黄附子甘草汤，虽然无里证，也不能用麻黄附子甘草汤，你得用桂枝汤加附子，就是这个意思，所以我们对这个方剂的应用的标准，就是桂枝汤证而现少阴病。当然了本段的说法也可以作参考嘛，汗漏不止哪，四肢拘急，难以屈伸哪，恶风的厉害，不发烧。发烧也不一定不发烧，但人不发热。

李冠杰：这又是一个桂枝汤的加减。这一条在《康平本》里边，我们可以认为它是《汤液经》的内容。

我们直译过来：本为太阳病，因发汗不当，于是造成汗漏不止，病人恶风、小便难、四肢微急、难以屈伸的，为桂枝加附子汤主之之证。

下边我们也解读一下：

因为这一条比较规范，我们把这一条作为学习的重点，力求能从各个角度，把这个条文涉及的方方面面都跟大家说清楚，为我们以后再遇到类似的问题，打下一个比较好的基础。

条文开头冠以“太阳病”，前边曾经讨论过，从理论上说这个“太阳病”应该既包括表实证也包括表虚证，但是具体到这个条文里边，表虚证的可能性相对地要比表实证的几率要大一些，因为它后头是一个汗流不止的结果，虽然冠以“太阳病”，但是表虚证的成份应该多一些。

“发汗，遂漏不止”，这是一种论述方式，在《伤寒论》里边比比皆是。我们把它当作后边学习的一个层次的一个点，简单的几个字，里边却包含了很多的内容。因为它既涉及到前边的太阳病，又涉及到后边的方剂，还加上后边的一些症状，它都有联系性、连贯性的。它有个前提条件，就是太阳病，太阳病这儿又说发汗，太阳病发汗不是正治吗？为什么又出现了“遂漏不止”呢？我认为这个“遂”字应该当“于是”讲。太阳病发汗以后，于是出现了汗漏不止的这种情况。而我们不应该把它理解成本来就出汗，吃了发汗药以后，不管什么发汗药，反倒是又汗出不止了，看起来逻辑上好像说的通，但是如果真这么认为的话，以后你会认为这个人不可能出现这种情况了。不对，完全有可能出现。后边会跟大家讨论，“遂”在这个地方，于是就出现了这样的情况，这是一个既承接了前面，又承起下边的一个字。

“遂漏不止”，这个汗漏不止我们应该客观地全面地看，有三、

四种可能吧：一个是它本来是个表虚证，误把它按成表实证，吃错了药了，就是误治了。本来是个桂枝汤证误服了麻黄汤，完全有可能出现这种情况，就会汗漏不止，会出现这种情况。

第二种情况就是发汗太过，不管是桂枝汤证也好，麻黄汤证也好，都要求以“微似有汗”为度。如果让他发汗太过了，就会像桂枝汤的方后注里面说的“大汗淋漓，病必不除”。“病必不除”不等于说它还是那个病，它完全有可能转变成其他的病。这条说的就是因为发汗不当转成阴证了。

在临床当中我自己就遇到过一次这种挺有意思的情况。我儿子，他本来体格非常壮，那次感冒了，我当时根据他的情况服的是桂枝加黄芪汤，他是先洗了热水澡，后喝了药，我也想让他好得快点，再加上看他体格那么壮，我说你再喝点热粥吧，结果第二天他跟我说：昨天晚上出汗有点多，感冒倒是好了，但是觉得有点累。像这种结实的体格要说有点累，就是觉得很有疲劳感了，像他这种情况，如果体格不好的话，这一下就有可能就陷入阴证了，就出现这种情况了。

还有一种可能性就是其他的误治。比如烧针，像那些烙肤，好多其他的，但今天看到的不多了，实际意义不大。今天实际意义比较大的就是输液了。特别是有发烧的人，输一些西药，退烧的这些药，都会出汗。但是西药的发汗药，是纯属发汗。像中医里面最典型的发汗药麻黄汤，麻黄本身就不是一个单纯的，仅仅是发汗的一个药，它还有其它的作用。另外的药像杏仁、桂枝、甘草啦，这些药对人体都有某些补益作用。它在发汗的同时，还可以照顾人体的正气。但是西药却不是这样，它基本上没有这功能，发汗的药就是纯发汗。

我就碰到过这样的病人，输液输到后来症状基本上消失了，发烧啊、难受啊都过去了，没有疾病症状了。但是落下一个什么病啊？实际上那是一个典型的桂枝加附子汤证，落了一身病嘛，喝一口水就出一口水的汗，就喝一口热水马上就出汗，出完汗以后就觉得冷，冷了

以后就要穿上衣服，还要加衣服。这不是热天，大概是春季。实际上那就是典型的桂枝加附子汤证，看着症状是消失了，其实是误治了。

这种汗漏不止的病理，我们也应该认识一下。出大汗的时候，不仅仅是一种情况，比如四逆汤证有可能出大汗；通脉四逆汤证，包括白虎汤证也有可能出大汗。这个地方你要是把他的病理有所认识，遇到这种病人你很快就能感觉到，能辨证出是不是这个方证。

这个病症是因为一方面人体有表虚的情况，另一方面人体的机能陷于沉衰了。人体机能陷于沉衰以后，最直接的表现就是精神不好，无精打采，非常困乏的样子。因为机能沉衰又有表虚，他本身的表虚证就是因为机能的不足造成汗毛孔关闭的能力差，有些失控。一旦人体陷于阴证，里边的功能也不足了，这种情况就会更加严重，所以汗出的情况比桂枝汤要严重得多。跟我刚才说的，喝一口水马上就觉得要出汗，这一口水的水分，感觉到就得在皮肤上出来，就是那么失控的程度。

他这个汗也有别于表实证，或者说是桂枝汤证发汗过多，但是没有形成这种情况，那个可能是大汗淋漓，但他是个短期的，过去以后就没有了，或者逐渐地自己减轻了；这个却不是，他没有丝毫减轻的那种趋势，是一种相对地稳定的病理状态。

你要是知道这个，看到病人还没往你面前坐的时后，其实你就应该有感觉了。他来的时候，走路都没有劲的样子，那不是一身的困乏、没有精神？你一眼就能看得出来。

后边还有“其人恶风”，这个“其人恶风”在这个地方有两层意思：一层意思是他本身以前的表证没有好，另外一层意思就是这个人陷于阴证以后，一直在汗出，他恶风的情况要重一些。所以作为一个典型的症状，把它放在这个地方，实际上还会有其他的症状。比如疲惫、困乏，这儿没有写。经方只给你说典型的症状，不典型的症状你也应该知道它，你看到方剂就应该知道它可能会有。但是有和没有都

没有关系，都不会影响这个方剂的使用。关于这一类的问题，我们还要详细地讨论。

再一个症状是“小便难”，从病理上说这个“小便难”是怎么来的？是因为表虚太严重，再加上机能沉衰，根本就对体液控制不了，前边严重的发汗，大量的体液都从体表丧失了，这时候体内的水分相对地减少，小便的量就会明显地减少，或者是不通畅、有点困难，但不是像严重的肾功能发生其他的病变的那个样子。从历史上的注家看，他们都认为这个附子是补肾的，所以说这时候人的肾脏已经出现问题了，实际上更多的因素来自于体液的丧失。从临床统计资料看，这个方证里边有可能出现小便频数的情况，但小便频数绝对是量非常少，这反倒是肾功能不好的缘故。因为他机能沉衰（肾功能），控制小便的能力变差，所以像真武汤那样子，有一点就要赶紧排出来。

“四肢微急，难以屈伸”字面的意思是四肢的活动不能自如，有很多的原因可以造成这个，比如患了脑血栓，自然存在肢体活动障碍；像运动神经障碍，也会出现四肢活动不灵便。我们还得从疾病机理这个层面上有所认识，你才在临床当中容易判断。这个方证的四肢活动不自如实际上是一种四肢的拘急，是因为体液损失太多，肢体的肌肉组织失养造成的。

还有这种情况，喝酒大醉以后出现，一是酒精中毒了，另外是吐，亡失人体津液，严重的时候就会导致出现四肢抽，现在遇到这样情况好多人都去输液，实际上输液这类东西，当然也是补充水分了，不如中药快。我曾经用泽泻汤合上小半夏汤再加上人参，吃下去以后像这种肢体拘急，十分钟解决问题。用这样的方子就是从它机理上来考虑的，体液丧失太严重了，而且人又吐，是因为胃对水分不吸收，酒精中毒胃大概属于麻痹状态，胃的吸收水分功能变弱，包括生姜、半夏都有改善这方面的功能。对付胃中的停饮，泽泻汤就比较好，再加上喝醉酒以后那个头的感觉，头的不清醒就是用泽泻汤，他确实喝了以

后，一会人体就感觉到四肢活动灵便了。

这个方剂实际上就是桂枝汤的原方加了一枚附子。方后注里边有一个比较特殊的，因为咱们学《康平本》，刚接触到。“右六味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升”，后边是“将息如前法”，也就是说后边的护理跟桂枝汤要求的一样。嵌注“本云桂枝汤，今加附子”它加在正文之间，像这一类文字我们很难说它是谁写的了。

如果揣摩一下，这个嵌注是不是张仲景写的呢？如果是张仲景写的，是不是在桂枝汤的基础上，张仲景创的这么一个方子呢？这一句话在这个地方想做一个解释，我觉得古人很少用这种方式来表达，桂枝汤已经给你写得很明白了，后边还特意再给你注解一下？我想这不像古人的行为风格，恐怕是这个文字的作者他发明的这个方剂。至于这样说呢，只是自己的一种猜想而已，没有任何依据。

这个方剂也非常好理解，附子这个药我们简单地说一下，因为后边还有很多的方剂涉及到它，附子是温性的，有亢奋作用的一味药。它对的病理是阴证，就是人的机能偏于沉衰，或者一部分机能偏于沉衰，用附子都有好处，它都可以治。有的方剂明显能看出来，用附子并不特别的合适，但是要的就是附子振兴机能的这种作用。比如肾气丸八味药里边，后世把桂枝和附子去掉了，改成六味地黄丸，就成了一个典型的寒凉的药。但是肾气丸对的是一种虚热证，又虚又热，又有血虚又有血瘀还有停饮，是这样的一种病理状态。但是他有热，这个热你要说桂枝和附子用到里边不太合适，但是，就是因为机能沉衰的厉害。机能沉衰到喝了水以后下焦都控制不了，喝多少尿多少，或者感觉到小腹麻木不仁，那都沉衰的挺厉害，离了附子桂枝解决不了。但是这两味药又特别偏于温，那么减少用量，用量都比较少。大家看看古人经方的方剂用药非常的巧。

我们具体地来看一看这个方剂的适应证，它治一些什么病？我们把临床统计的资料比较详细地跟大家做一个介绍，看看能够得到什么

样的启示？

这个方证笼统地说，这一类的病人大致表现是，像恶风寒、汗出不止、头痛或者身痛、神疲力乏、手足不温、面色不华、小便难或者说小便频数、四肢微急。因为现在要详细讨论这个问题，就说它这么多的症状，是不是在一个人身上都会表现出来呢？绝对不会；这些症状是不是全面呢？也绝对不全。大家可能会提出这样的问题，既然不是每一个病人都表现为同样的症状，而且出入又很大，那么这个方剂的适应症，能给我一个准确的说法吗？不幸的是，它就是一个综合的症状群。临床当中我找了一个统计资料，比较简洁，但是它能说明问题。上面这些东西，我们说它笼统，它也是有依据的，是从临床当中来的。这个统计资料统计了 119 例，其中有汗出的是 79 例，恶风寒的是 76 例，肢体凉的、冷的 42 例，神疲体倦的有 34 例，面色不华有 32 例，发热的有 26 例，纳呆少食的有 25 例，头痛的有 25 例，身疼痛的有 19 例，小便不利的有 18 例，肢体拘挛的有 17 例，心悸有 15 例，还有其他的证都不足 14 例，因为出现的几率低就不作为典型症状来记录了。

脉象的统计，因为有好多医案不记录脉，或者有的是记录单脉有的记录复脉，这里边差别比较大。脉象是沉细无力的脉是 9 例，浮缓的脉是 8 例，沉弱的脉是 8 例，浮紧无力的脉是 5 例，迟缓无力的脉是 5 例，还有一些单脉，比如沉脉记录有 17 例，浮脉有 16 例，细脉 14 例，缓脉是 8 例，弱脉是 8 例。从这个脉象上大家肯定会有感觉的，我们后边再说。

舌像，舌质淡是 14 例，淡红是 4 例，红 3 例。

舌苔总共有 30 例，苔薄白的 16 例，苔白的是 5 例，少苔的 3 例，白腻的 2 例，无苔的 1 例，白滑的 1 例，水滑的 1 例，滑润的 1 例。这是从症状这个角度看，也就是从患病以后的疾病反应这个角度看。

看完了会不会有这样的感觉？如果单纯地看一个症状或舌像或舌苔或脉象或某一个症状，其实你根本就没法确定它是一个什么方证。从这些统计数据还能看出其他问题，比如单纯的凭脉用药的，单纯的凭脉诊病的，就光是这一个方剂统计出来的这些脉，站到统计资料面前，就是一面镜子，什么东西都给你照得很清楚，关键是你想不到的问题。如果作为统计分析的话，你能不能把这个情况分析出来。大家看前边三大项：一个是沉细无力，一个是浮缓，一个是沉弱，这脉就相差的很远了。浮缓的脉和沉弱的脉，除了弱这一点上有点近似以外，在手下的感觉就差远了，一个浮一个沉。如果没有其他的症状做佐证的话，你凭着一个脉，根本就没法确定疾病的性质。不幸的是所有经方的方剂都有这种属性，我们在这只是一个解剖麻雀，就把这一个方剂剖开，大家就会发现这是一个非常严重的问题。上溯到王叔和以脉定证，一直到我们今天，还有人在极力地去推广这些东西，把脉诊说的可以代替一切。我们不否认你经过艰苦的练习以后，你可以诊病诊得比较准确，甚至于跟医院里边的那个检查结果吻合度很高，但又管什么用啊？你依然解决不了用药和用方的问题。

既然这些证这么杂乱，我们临床当中怎么去辨证呢？如果这个人表现为汗漏不止、小便难、四肢微急的话，那我能辨哪，如果也有这个证也有其他的证，甚至这种证只有一个，比如就有汗出这一个证，其他的没有，那我怎么辨啊？大家想想我们那个辨证体系，我跟大家讨论过那个问题，就是那个辨证体系干什么的？它就是在方证的基础上总结出来的病理体系，反过来指导临床。当你有个大汗出的病人，假设你还是一个生手，你首先想到的是白虎汤证，你就去找里热的依据，如果那个病人是个桂枝加附子汤证的患者，你能找到里热的依据吗？找不到，那么里热这一大项的里证和热证一下就排除了。这个汗出看看是不是表虚？然后你再通过脉，通过舌，通过问，通过他这个病的发展，你认为是表虚。表虚我是给他桂枝汤啊，还是给他桂

枝加附子汤啊？那你再去找找他有没有阴证，他的那种疲乏程度，他脉的那个迟缓程度，是不是有桂枝汤解决不了的问题啊？如果是，那他有了阴证了，有了阴证你就得加附子嘛。这是一个方面。

我们再看另一面，就是疾病。桂枝加附子汤在临床统计资料当中有应用机会的这个现代病名，我给大家念一念啊：风心病、冠心病、心律不齐、室性早搏、慢性胃炎、慢性肠炎、胃肠型感冒、流感、风湿性关节炎、周期性发热、坐骨神经痛、脑出血、麻疹、小儿虚脱、小儿麻痹症、肌肉痛挛、血栓闭塞性脉管炎。这些疾病涉及到了人体多个部位和好多性质完全不同的疾病。像麻疹跟风心病风马牛不相及吧，但是他都有用一个方剂治疗的机会。

再换一个角度，大家听了以后可能也有别的认识。中医的病名有的资料也做了一个统计：漏汗证、阳虚自汗证、太少两感漏汗证、太少两感证、阳虚浮肿证、半身多汗症、半身闭汗证、过汗伤阳、阳虚致痉、产后漏汗、产后恶风、乳漏、经少带多、盗汗、冬季腰痛证、太阳风湿、四肢微急、十指疼痛、风寒咳嗽、半身不遂、痿证、发热。中医的这些病名，其中也有证，而且还相当的不规范。另外有一些病名本身就是一种误导，如果把那些病名放到经方里边，比如太少两感，放到经方里边有点不太对应，对经方理论理解的不到位，就给起了一个名字。还有些挺有意思的，比如半身闭汗证和这个半身多汗证，实际上这是一正一负，半身这边不出汗，那边说出汗厉害了，就成了另一个证了，就成了半身多汗证。但是这儿提醒我们，如果遇到病人半身半边身出汗，你就会联想到有没有用桂枝加附子汤证的机会。

我们通过对中医西医这些病名的大致了解，这些病相差很远，包括中医病名里边还有一些妇科病。但是都有这一个方剂治愈的那种机会，这说明什么？这个问题很重要，如果学经方解决不了这个问题，你用经方很难用到很精到的那个程度。

现在很多普及经方的一些大师级的人物，有的在强调人的某些疾

病，某某方剂是治某某疾病的特效药，大家看经方没有这种规律。真正有规律的是，它跟上边我们说的那些方证，尽管很乱，但是乱中有规律。只要有几个典型的方证，组合到一块，同时出现在一个人身上，你能证明他是表虚证，而且同时又陷于阴证的话，那你用这个方剂就不会出现大的问题。如果再有这个方证的几个具体症状的话，那用来就绝对疗效好。但是病就不存在这样的规律了，不过如果仔细看也能看出一些规律性的东西，像这个病，就是跟汗出有关的一些病了，相对地比较侧重它，仅此而已。它没有一个特定的规律在里边，没有一个稳定的对应关系。稳定的对应关系应该是在病理指导下的那些方证。如果病理能对上，那些方证又没有其他方剂的方证，都是这个方剂能够解决了的，这个方剂下去准好。试多少次都是非常灵验的。这也就是经方的一个最基本的规律，经方治的是什么？治的是证。尽管这个证不是一个单纯的脉，也不是一个单纯的证，它是一个有规律性的综合的证候。只要这个综合证候对上了，不管男女老幼，不管病人是什么情况，也不管是什么季节，用下去他就能好。

但是方剂和疾病之间就没有这么稳定的对应关系。因为方证的症状是若干症状合到一块儿的时候，它能说明问题，能够确定方剂应用的指征。疾病没有这种特性，如果这个人得的又有心脏病，又有脑出血，又有小儿虚脱，又有脉管炎，哪有那样的？它不是这个意义。

如果再深究的话，这个问题就是一个非常严重的问题，严重到涉及疾病划分的程度。就说今天这个桂枝加附子汤证，经方理论认为这个人得的是一个阴性的表虚证，这是大的方面，小的方面他可能会出现汗漏不止，小便难啊、四肢微急这样的情况。他得的什么病啊？就是阴性的表虚证，机能陷于沉衰的表虚证，他就是这种病。只要是这种病再加上具体的症状是这个方剂对应的那些症状，你用这方剂就能治好。这就是经方对疾病的划分，阴性表虚证。它不是一个具体的什么病。

看起来好像是太笼统了，好，有不笼统的，中医对疾病的病名和现代医学对疾病的病名都划分得非常的详细，看着也非常的科学，但是真要放到临床统计资料上一验证，拿这把尺子一量，他对不上了。特别是在现代医学，它治疗这些病，用同样药的机会那是不可思议的事，可能性都没有。治感冒和治冠心病，有用一样药的吗？但是在咱们经方里边，这都是完全可能的，经方的这一套东西看起来很模糊，是一种模糊中的精确，却最终可以和临床统计资料相吻合。现代医学和中医的其他那些病名，之所以病的名字不一样，就是因为治疗方法不一样，这种对疾病的划分本身就有问题。我在跟大家讨论经方辨证体系的时候，就一再强调这个问题，两个人得的是按西医认识是相同的疾病，但是用不同方剂治好了，这就说明他们得的不是同一种病。听起来天方夜谭，但是实际上这是事实。

我们学这一条，通过延伸，我们需要知道的，其一一定要把方剂和疾病的关系，和症状的关系弄清楚，弄清这个问题，入经方的门就非常简单了。

还有一个很具体的问题，就是经方里边经常会出现病因。虽然刚开始看好像比较含蓄，他没有直接说是误治，比如“太阳病下之”，如何如何，那肯定就是误治了。这个地方说太阳病发汗以后，他遂漏不止，那不也是个误治？这也就是一个病因了。后世在解释经方的时候，很多都是机械的照搬，说这就是一种太阳病经过误发汗以后如何如何。如果不是太阳病，他本来一得病就是桂枝加附子汤证，他是少阴病，我们就不能用这个方剂了吗？不是，一样用。经方的其他条文里面很多条文都涉及到病因，我们应该怎么来理解这个病因？实际上这是古人非常高明的地方。我在这儿试着跟大家分析分析，大家看看是不是这么回事。

第一层意思，是说造成后边这些疾病的原因之一，但不是唯一的原因。比如太阳病发汗不当可能会陷于阴证，这是造成阴性表虚症的

一个原因。没有这个原因，如果是阴性表虚证也可以治。大家要时刻记住这一点。

另一层意思是误治可能出现的不良后果，比如发汗太过了会出现不良的后果。这个是陷入阴性表证，表虚证，还可能会出现阳性里热证。

第三层意思，对正确理解条文里边的病理起到一个很重要的诠释作用。这个条文就是这个人发汗太过了以后，人弱了，发汗太过不就是损耗人的正气吗？中医里不是说“血汗同源”嘛！就是对人体的体能消耗太大，以至于人体陷于沉衰，就出现了这么一种情况。

第四层意思呢，重申治疗禁忌，具体到这一条里边，就是太阳病应该发汗，但是发汗不要太过，太过以后就有可能出现这种情况。

还可以理解后边的治疗方法，理解附子的作用，再进一步深入理解桂枝汤作用，前边的这个病因都能起到一个比较好的诠释作用。从这个意义上看，古人看起来轻描淡写的随便给你带了几个字，但是里边含义是很深。

我有一个比较典型的医案，一个八九岁的小男孩，整个过程就跟这一条论述的非常相似。最初的时候是这个小孩的姨妈带着他的表妹来看病，当时开的是小青龙汤证，给了她6剂小青龙汤，6小袋。这个孩子主要是咳嗽发烧，回家吃了一袋，基本上症状就差不多消失了，后来又吃了一袋，就完全好了。结果就在这个茬口上这个小孩的表哥出现了这个症状，然后她妈妈就跟他姨说，我孩子在医生那拿的药，吃了马上就好了，也是发烧咳嗽，剩下的药你让他吃了吧。这个小男孩的妈妈就把药拿回去就让他吃，吃完了以后不管用。她警觉起来了，她在我这看过病，就给我打电话，她说我妹妹家的孩子吃了管用，我的孩子吃了不管用呢？我说你赶紧来看，千万以后不要这样，中药不是这么吃的。过来看了看，是葛根汤证，葛根汤回去吃了以后就好了，我给大概是三四天，他大概也就吃了一两天就好了，剩了一些放了大

概半年多吧，她孩子又开始这样，她想起这个方剂就让他喝了，孩子出了点汗，烧稍微退了退，半夜里边又烧起来了，她一看这个方子不管用啊，她知道我的方剂基本上像感冒这类的病吃了就好，她又弄了其他的发汗药，至于是什么药，她也没跟我说清。到了下半夜，孩子吃那个发汗药大汗淋漓，烧是退了。到了上午又烧起来，后来跟我联系，这个孩子最后就是吃的桂枝加附子汤。下午四五点钟吃了一次，到了晚上八九点又吃了一次，晚上十一点她就给我打电话，说孩子出了点汗，退烧了。第二天体温稍微还有点高，到第三天第四天差不多就基本上正常了，孩子就好了。

这实际上也是一个误治，跟那个条文里边论述的就比较相似。但是经方治疗，在临床当中一个很重要的原则就是有没有这个病因，这不重要，重要的是他是不是这个方证。只要他是这个方证，有这个病因可以用这个方子治，没有这个病因，一样用这个方子治。经方治的是他的适应症，跟病因，跟疾病没有稳定的对应的关系。

大阳病下之后、脉促胸满者、桂枝去芍药汤主之、（21）
若微恶寒者、桂枝去芍药加附子汤主之、（22）

桂枝去芍药汤方、

桂枝三两去皮 甘草二两炙 生姜三两切 大枣十二枚擘

右四味、以水七升、煮取三升、去滓、温服一升、（注）

本云桂枝汤今去芍药·（例）将息如前法、

桂枝去芍药加附子汤、

前方加附子一枚、炮去皮破八片

右五味、以水七升、煮取三升、去滓、温服一升、（注）

本云桂枝汤·今去芍药·加附子·（例）将息如前法、

胡希恕：这个脉促，各家的注解我认为都有问题，都根据王叔和的说法，说是“数中一止，谓之促脉”。就是快脉，有时候一止，我认为欠通，这个不对。凡是“一止”，脉跳跳一止，就叫作结脉。无论数中见之，或迟中见之，都叫作结脉。结脉有数有迟，那么这个促，咱们平时说短促，近，促近，就是靠近。这个促脉，就是促与上，与外的意思，就是靠近于上，靠近于外。靠近于外，就是只见到上头，上头就是寸位。所以只是关以上浮，关以下沉，这么一种脉象。尤其这一段，更注意说明这个问题，你们看看这一段，他说下之后，我们头前讲的桂枝汤，“太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，如前法”，也是今天讲的。

那么这一段的“胸满”是什么东西？就是气上冲啊。他吃了泻药了，下之后，太阳病，不应该下，吃了泻药了，就气上冲，气上冲可表没解呢，气上冲以至于胸满，冲的挺厉害。气冲于上，同时他由于吃下药，虚其里。那么可见上实，气冲的关系，下虚。脉也应之，浮见上头下边就虚。所以这个脉与证是相应的，绝不像他们说的“数中一止”，没有那么大的热，那么大的热他不就烧起来了，不是，促，都是热，他这个不是，他由于气上冲，那么上边，所以这个脉，他浮在关以上，叫促。

而由于泻下的关系，腹气虚，所以这个下脉沉，关以下沉，应该是那个脉。那么由于表没解，还用桂枝汤，同上边桂枝汤一样，由于这个浮，虚了，我们后头就有了，桂枝加芍药，“腹满时痛者，桂枝加芍药”，他把芍药三钱增到六钱，腹满时痛要加芍药。在这儿把芍药去了你想什么道理？腹虚，不但不满，而且腹气虚了，所以他把芍药不要了，这个我们在临床上用芍药的确是治腹满，我常治肝病啊，常治肝病把芍药大量用，这个下腹满他就起作用，那么满的反面就是不满，虚的厉害了反倒，那就要去芍药，这不就是这个道理。那么底

下虚，上头实，所以脉也应之上浮而下沉，这不很对嘛！决不是数中一止。

那么这个桂枝去芍药，就是这个桂枝汤证气冲的更厉害，我们刚才讲了桂枝汤，芍药这个药呀，能制桂姜的辛散。那么气冲的厉害，这个桂枝要发挥作用，桂枝治气上冲，所以芍药在里头有碍于桂枝，同时腹气虚，它也不应该要，所以把它去掉了。那么这个方剂的体会呀，就是桂枝汤证气冲比桂枝汤较为厉害一些，而胸满，脉促者，我们根据这个来用它，没问题。这是桂枝汤的一个变化，桂枝汤去芍药，这个方子加减也挺管用，以这个方子为基础。另外还有一个变化，就是桂枝汤把这个大枣生姜也去掉了，就是桂枝甘草汤，这是桂枝汤又一个变化，桂枝汤有这么三个大阶段。这是一个，这个就是胸比较满，桂枝治气上冲，那么他又是腹气比较虚，所以把芍药去掉。

这段和 21 条应该是一段，这个书搁成两段了。成无己本为一段，他说“太阳病，下之后，脉促胸满者，桂枝汤去芍药汤主之，若脉微，恶寒者，桂枝去芍药加附子汤主之”。它是一段，这个书它搁成两段，两段这个前后就是不对头了。而且成无己他给改成“微恶寒”，“微恶寒”不对，他不是恶寒，假设是微微恶寒的话，那正是表不解嘛，加哪门子附子呀？“微寒”是对的，这个“微寒”是接着上面这段，就是“脉促胸满”，如果微陷于阴寒证，微寒，没有那个恶字，赵开美本是对的，在《玉函经》是“微寒”，不是“微恶寒”，就是微陷于阴寒证。那要加附子，那和桂枝加附子是一样的。桂枝去芍药加附子这个方子运用很多，后头的《痉湿喝病》风湿相搏里就用这个方子起作用了。桂枝汤证胸满上冲比较剧胜一些，而满脉促，他要用桂枝去芍药。这个证，如果陷于阴寒证的话，要加附子。

李冠杰：原文是这样的：“太阳病，下之后，脉促胸满者，桂枝去芍药汤主之”。下面的内容在《宋本》里边是第 22 条同，在《康平本》里这两条是同一条内容，是一段文字。我们就把这两段文字放

到一块儿来学习。下面的内容就是“若微恶寒者，桂枝去芍药加附子汤主之”，这条在《康平本》和《宋本》有很重要的一字之差，《康平本》第 22 条开头，也就是这仅有的一个症状“若微恶寒者”，那么《宋本》是“若微寒者”，没有这个“恶”字。这里边差别不小，咱们在学习的过程中会具体的讨论。这两条在《康平本》里边也是顶格的条文。

顶格的条文我在平时习惯把它整理了之后，我确定为这是一级条文。我在整理资料的时候，比如说《伤寒论》我有一个资料，就是《伤寒论》的条文明细，就是把每一条条文都拆开，这一个条文它自己就占一页，如果我想找第 21 条，打开这个文件夹找到目录的第 21 条就行了。但是我目录当中有一个名字啊，这个名字其中就分 ABC，凡是顶格条文呢都属于 A 级的。在春节前后开始跟刘观涛老师交流的时候，他曾经有一个建议：按照《康平本》的这种分类，是不是把每一条前面加一个小人头。比如说那个退一格的条文加上张仲景的头像，退两格的条文加上王叔和的头像。这种方式想得非常好，很奇妙啊。但是随着学习的深入，我们会发现这个东西也不是百分之百可靠的。比如其中大部分方剂都是降一字格的，方子和方后注基本上都是降一字格这种排版方式，但是有的方剂是顶格的，有的方剂是退两格的，这是一种情况。还有的段落，同一段落的文字出现了前边的文字是降一字格的，最后几个字是顶格的，这就明显的肯定是抄错了。考虑到有抄错了这方面的原因，所以有一些条文还不能简单地把它套上去。比如第 140 条，那条就完全是以脉定证，它是降一字格排版的，按我们简单的分类大概就属于张仲景的文字，但那绝不是出自张仲景之手，一看就知道是王叔和写的。所以我们不能机械地、过于依赖于某种形式上的东西。随着我们学习的深入，这些问题都会碰到，碰到的时候我会跟大家详细的来做分析。

特别是通过今天的学习啊，大家能体悟到这么一点，我们之所以

讲每一条的时候都会提到《康平本》，是因为《康平本》的价值随着我们学习的深入，你会越来越体悟到它的重要性。

这两条我们也做一个直译，用我们今天的话就是说：太阳病误下之后，表现为脉促胸满的，为桂枝去芍药汤主之之证；如果同时又伴有微恶寒的，为桂枝去芍药加附子汤主之之证。

下面呢我们解读一下：

“太阳病，下之后”，这肯定是误治。尽管咱们学的条文不多，但是碰到这类情况我已经跟大家说了，太阳病的正治是发汗，如果用泻下的方法治疗，这就是误治。误治的结果或多或少就会造成里虚的情况。但是我们现在还不能完全这么说，应该说它不仅表证不能得以解除，而且它还会伤到里，也就是说对人体的整个消化道系统造成一定的伤害。但是伤害的结果会是多种多样的，有的是表仍不解，还需要去解表，比如人体平素的体质比较好，下上一两次还不至于到影响大局的情况，虽然有一点变化吧，但它主要还是表证，就要继续解表。按照经方的治疗原则，应该还是服桂枝汤了。但是也可能会造成各种各样的变证，这个地方呢就是其中之一，相对说这是比较特殊的一种情况。因为这个地方主要是讲表证为主的，经过下了以后表证还没有完全好，但是又有了新的症状，是这么一种情况。

下面的症状是“脉促”，这个“脉促”历代的注家有多种解释。但解释最多的就是按照王叔和的“数中一止”，也就是说脉跳的很数，然后它还会出现停跳的，就是出现间歇的情况。实际上这种脉象严格地说应该叫做结脉，而且这个脉象跟本条里的方证（方剂的适应证）也不相吻合。那是循环系统出了问题，心脏出了问题，但是这儿所治的不是。就是因为对这个问题的认识有所偏差，造成了一系列的偏差，后边会慢慢地跟大家介绍。

这个“促”在这个地方应该做什么讲？胡希恕有个解释，大家也可以去查一查字典，字典上有很多的意思，比较贴近于这个具体方证

的，应该是“短小”和“靠近”这两个意思。它还有一个“快”的意思，但是“快”在这儿不太合适。如果说脉数的话，它无非大概就那么几种情况，一种是有热，另一种是虚极了，但是都跟这个方证不靠谱，所以它不可能是这样一种意思。实际这个脉象应该是什么样呢？应该是短小又靠近，靠近上端。古人用了这么简单的叙述方式，让人感觉到非常费解，我们今天在学条文的时候啊，就存在几处有类似这样的意思，古人写东西前后都是互相佐证的。如果把它当做数脉来看，这个“促”本身有数急的一个意思，按这个来看的话，它跟这个方剂不能相统一，这个方剂所治疗的症状里边不应该有这样的脉象，所以一对照方剂就比较明白了。胡希恕怎么能够独具慧眼，把这个问题给澄清呢？就是因为胡希恕能把方剂和临床紧密结合，当然也不排除是参考了比如日本的一些学者的观点，但是能接受，这也是一个水平，知道这些观点的也不是一两个人，能接受的不多。这个“促”在临床当中具体是一种什么样的脉象呢？它实际上就是一个关尺（脉分寸关尺三部）偏沉的这么一种脉。这个事我也想了，一开始我没把它写出来，我以前理解它是一种寸脉独浮，也就是说摸起来只有寸脉浮。但是有时候啊如果人稍虚弱一点的话，可能寸脉就是一种近似于常脉，那么关脉和尺脉很沉，就是这个脉的上端，靠近手的这一端啊，寸脉的这个地方比较容易摸到，但是关和尺相比起来就比较沉的一种脉象。如果这样去理解的话，你会觉得古人别看用了这么少的文字，这么一种论述反倒是非常客观的。你要是说关尺脉沉，有时候或许也表现为寸脉独浮，关尺脉近乎于平脉这也是有可能的。但是总的说，这种脉象跟方剂的适应症是相应的，后边还有“胸满”嘛！这是这个脉象。

这个“胸满”形成的原因，就是因为“下”，它前面有个前提条件就是说“下之后”。因为有“下”这个原因，造成人的里虚。但是“下”也可能造成里实热的这种情况，也未必不可能，如果造成里实

热就不是这种脉象了。所以这前边有一个前提条件，就是说太阳病下了以后造成这样一种脉象，而且同时有“胸满”。这个“胸满”怎么来的呢？刚才说脉象的时候说里虚了，前面有“下”我们知道是里虚了。“胸满”就是因为这是一种特殊的气上冲的形式，换句话说就是下了之后，人体仍然保持着自表解除疾病的这么一种动能和趋势。因为前边有一个“下”的过程，所以里虚啊，没有表现为腹部的气上冲的这种形势，而是以“胸满”的形式表现出来。今天看，这是一种比较特殊的情况了，也许在两三千年以前的中国啊，这样的误治可能是一种常见的情况。

那么下了以后，里虚了应该怎么办呢？大家再回顾一下第15条怎么说的？“太阳病下之后，其气上冲者可与桂枝汤”。实际上这儿就可以定一个原则：太阳病不管是表实证还是表虚证，经过下了以后，人从某种程度上说就虚了，但是又没有虚到放弃在表这个程度，所以它还表现为气上冲。气上冲的实质就是因为人还有从表解除疾病的这么一种趋势，所以治疗还得从表解。但这个时候就不能发汗了，不管有汗无汗也不能发汗了。这是经方里一个很重要的治疗原则。

看这一条，如果再参照一下第15条，就非常容易理解了，我们还要用桂枝汤来治疗。从这一条我们就能看出来，这个书就是经典的东西，它前后都不相矛盾，都是一脉相承的。

这儿顺便再说一下“气上冲”，大家不要以为“气上冲”以后就得服桂枝汤。你看第15条说的什么？“可与桂枝汤”，那么会有别的情况吗？实际上这个“气上冲”有时候还会表现为其他的，这个脉象还跟我们今天学的脉象完全有可能相似，“气上冲”的表现形式是多种的，具有多样性。今天学的桂枝去芍药汤，这是比较典型的一个“气上冲”，实际上桂枝汤本身就有“气上冲”啊。另外还有，比如说桂枝加桂汤，这个“气上冲”就非常严重了。

在学习之前我在网上看了一个帖子，哪一个网站一下子想不起来

了，大概是“天下中药”还是哪个网站。那个帖子题目就是说的“治疗奔豚证失败案”，其中他就提到了那个治疗奔豚证啊，本来那个患者不完全是奔豚证，每天这个人都有非常严重的噎逆，就是暖气，一天发作一两次，发作起来连续的几十次甚至是上百次的暖气，而且在发作之前他感觉有一股气从下边开始往上来，似乎看着是奔豚证，但是仅仅一点像，最后表现出来的是暖气，那不是奔豚证。他用了桂枝加桂汤，但那个患者还偏热，吃了桂枝加桂汤以后不单单没效，还感觉不舒服。桂枝加桂汤本身就是比较热的药，再一个患者本身就不是桂枝加桂汤的症状。另外严格地说，桂枝加桂汤也不是治奔豚，它是“欲作奔豚”，就是气上冲得厉害。这个气上冲得厉害一旦出现暖气，它就不是这个方证了。暖气有治暖气的方子，你得用降气逆的方子。

你看苓桂术甘汤实际上也是一个气上冲，但是呢它有停饮，它表现出的最典型特征就是头晕。在这儿可以告诉大家，苓桂术甘汤有的人表现出来的脉象就是脉促。还有比如说苓桂枣甘汤，那不也是“欲作奔豚”嘛！苓桂枣甘汤是小肚子这个地方跳，它也是一种气上冲。茯苓甘草汤是肚脐以上跳，那也是一种气上冲。这都是这些方剂比较典型的症状，其实它们都完全有可能还伴有表虚证，因为从这些方剂里的用药就能看出来，这是一个气上冲的问题。

具体的桂枝去芍药汤证，它是表现为一种胸满，这种气上冲让人感觉到胸部非常满闷的一种感觉，这也是一种特殊的气上冲，那就得用桂枝去芍药汤来治疗。我们来再看一下这个方剂，它是桂枝汤的原方去掉了芍药这一味，本来是五味那么变成四味。《康平本》里桂枝的用量是二两，恐怕是抄写过程中的手误吧，因为《宋本》是三两，再一个我们看不出桂枝需要减量的依据，没有必要桂枝减量。这个芍药减掉它有充分的依据，大家看一看芍药的应用，咱们就看这个方剂就行了。四逆散，大柴胡汤，另外一个桂枝加芍药汤，这些方剂明显能看出来都是含有芍药的，都具有一些腹部满、或者实、或者痛的

这一类的症状。但是桂枝去芍药汤证，恰恰跟那些方剂在腹部的方证相反，这是一个虚证，因为下了以后没有变成其他的证，而造成里虚了。但这个里虚它没有其他的变证，比如大便溏泻了，或者是出现腹痛了等等其他的变证，如果有其他的变证，这个方剂恐怕也就不好用了。它没有出现其他的变证，腹部没有气冲的感觉，就是说已经有里虚了，可是胸部还有胸满，这个胸满就是因为气上冲造成的。那么这个时候呢为了保证疗效，就把芍药给去掉了。我们做一个假设，让他服桂枝汤原方行不行？我想如果服桂枝汤原方的话，也许多服上几天，也可能能好，但是这个治愈的周期会加长。

另外呢，如果说加上芍药以后啊，芍药和腹证有点不对路，相反。芍药会进一步地使里虚的状态更加严重了，轻了它会影响治疗效果，严重了可能造成无效或者再造成其他的变证。我们可见古人在临床中体悟出的这些经验啊，已经非常得细致，而且也很到位。

我们再把这一条简单地回顾一下。这一条它说的病理状态，实际上就是一个阳性表虚证略偏于里虚证的一种状态，但是里虚证又形不成真正的病理反应。就是这样一种病理状态。简单地可以这么理解，它实际上就是桂枝汤证又现脉促胸满。为什么这么说呢？它肯定还会伴有其他的表证，我们应该这么去理解，不要把眼光全盯在脉促胸满上。之所以把“脉促胸满”放在这个地方，就是要让我们从中学习到这个病理的特征。

关于这个方剂和条文，可以这么说，在历史上应用这个方剂的真挺少，用得对的就更少。在临床统计资料中，这一方面的资料非常少，不是这个方剂的临床统计资料的量少，而是正确的少。原因就是王叔和的误导，说这个“促脉”是一种“数中一止”的脉。大家想想，根据“脉促胸满”，把脉促理解成这样，这也就是一个胸部症状。所以绝大部分的注家，我们现在正规的教材也是这么讲，说这是一个胸阳受损，因为下的太厉害，伤到了胸阳了，没伤到里。用经方的理论说，

没伤到里而伤到了半表半里，伤到了胸阳了，造成了胸部的一些疾患。所以临床统计资料中它治的疾病都是哪类的疾病？心脏病、肺部的疾病，大部分都是这类的疾病。为什么会这样呢？咱们得仔细看，如果不仔细看的话，这些统计资料马上就能误导你，你一看这不是用这个方子可以治心脏病吗？但是换一个角度想想，桂枝汤把芍药去了可以治心脏病吗？而且是一些冠心病、心力衰竭这样的病。怎么会治这样的病呢？你带着这样的疑问再去看这些临床统计资料，就会发现，它实际上是用的桂枝去芍药汤加上麻黄附子细辛汤，治疗心脏病是麻黄附子细辛汤的作用，而不是这个方剂的作用。换句话说，大部分人因为理解的错误，在临床当中这个方剂没有正确地用过，我们且不说临床当中真正碰到的这样的病人多和少，就说这样的理解偏差，别说轻易遇不到一个，就是遇到你也不会用。所以说，这一条和下面第 22 条的桂枝去芍药加附子汤，它们犯了同样的问题。

所以包括临床统计的症状，临床统计的现代病名，一概不再跟大家介绍了，因为那些东西是有问题的。在这儿跟大家说了，再去解释它为什么不对，没意思了！大家知道这一点就行了。我们从这儿也能看出，对经方理论只要是在理解上出现一点偏差，那到临床当中你就会相差万里。这也正是为什么社会上多少年以来，就形成了这么一种局面：所有的人都说经方好，但绝大部分中医都不用经方。根本原因还是在理论上出现了问题。

第 22 条也值得我们推敲。在读这一条的时候，不知道大家是不是看过胡希恕的讲座，胡希恕在讲座的时候说，这两条本来就应该是一条。从这儿就能看出胡希恕在这方面非常严谨，从来不是说机械地去套用某一个。而且我们从这儿也能看出来，胡希恕就没有见过《康平本》，如果见过《康平本》的话，他肯定会说：“在《康平本》这两条就是同一条”。也就是说胡希恕这一生就没有见过《康平本》，挺可惜的。我想如果胡希恕见到《康平本》的话，他肯定会如获至宝

的。我现在有时间我还会再整理胡希恕的讲座，在读的过程当中，你看看《康平本》，再看看胡希恕的讲座，你会发现他就跟有意似的，凡是这些降两字格的条文，他讲得要么是批判，要么是轻描淡写，要么会费很多的周折，去牵强地做一些解释。而且能感觉到他自己心里边都觉得很别扭，就说明胡希恕真正是读出了经方的内涵。

那么这个第 22 条，“若微恶寒者”应该怎么去理解？这是一个最主要的。如果从字面上看，胡希恕有一个解释说这个“微恶寒”不应该有这个“恶”字，用我们现在的话说，就是《宋本》应该是对的。但是我们要仔细地推敲一下的话，“微寒”是什么意思？如果说不是“恶寒”的话，“微寒”就是人体稍微有点偏寒，对不对？应该是！如果说人体稍微有点偏寒的话，大家想想桂枝汤把芍药去了，桂枝汤本身就是一个温药，里边只有芍药算是一个明显偏于寒的药，而且又把它给去掉了，如果说微微有一点偏寒的话，那恰恰是桂枝去芍药汤所治。这似乎让人感觉到有些不太通。那么，我跟大家换一个角度，如果我们先给它加一个字，为了大家好理解，“若微恶寒者”在“微”字的前边加上一个“脉”字，“若脉微恶寒者”，形成了什么呢？就是一个脉微细，恶寒明显的这么一个症状。如果碰上这个症状的话，再加上胸满，用桂枝去芍药加附子汤，正好！我们再反过头来看看原文，如果我们在原文的“微”字的后边点上一个逗点，大家再看原文成什么样了？“若微、恶寒者”，这个“微”就正好和前边第 21 条的那个“脉促”相呼应。如果这么理解原文，它更贴近，更跟这个方证相贴切。但是这是我的一家之言了，是我自己的一个想法，大家可以仅作参考吧。从方剂来看，如果这个病人出现脉微细，同时又有胸满，而且是一味恶寒，如果出现这种情况的话，那么用这个方剂应该是恰好的。从经方的辨证的角度看呢，这条论述的就是桂枝去芍药汤证又陷于阴证的一种病理状态。

另外还有一个挺有意思的地方，这个桂枝去芍药加附子汤在《康

平本》里没有方剂，仅有“前方加附子一枚”这么一句话。前方就是指的桂枝去芍药汤了，加附子一枚，有了量了。这样的论述方式更附合古人的写书习惯。我们还可以进一步地再去想，从这一点上大家再去看一看，谁还能说《康平本》是从《宋本》改写而来的，可能吗？有谁会在改写的过程中，平白无故的把《宋本》中写得非常完整、既有药味又有剂量、又有方后注的一个完整的方剂一下给抹掉，换成这么一句话？有人会做这样的事吗？这不可能的。所以说，只有《宋本》有可能是在《康平本》的基础上进一步地经过添加改写而来的，而《康平本》绝对不可能从类似《宋本》这样的版本篡改过来的。那是不可能的事，没有人可能做出这样的事来。这是第 21 条和第 22 条。这个桂枝去芍药加附子汤，它的临床统计资料当中犯有同样的问题，所以我们就不要去跟大家介绍临床统计资料了。

大阳病、得之八九日、如疟状、发热恶寒、热多寒少、
其人不呕、清便欲自可、一日二三度发、（注）脉微缓者·为欲愈也·脉
微而恶寒者·此阴阳俱虚·不可更发汗·更下·更吐也·面色反有热色者·未欲解也·（经）
以其不能得少汗出、身必痒、宜桂枝麻黄各半汤、（23）

桂枝一两十六铢去皮 芍药 生姜切 甘草炙 麻黄去节各
一两 大枣四枚擘 杏仁二十四枚汤渍去皮尖及两仁者

右七味、以水五升、先煮麻黄一两沸、去上沫、内诸药、
煮取一升八合去滓、温服六合、（注）本云桂枝汤三合·麻黄汤三合·并
为六合·顿服·（例）将息如上法、

胡希恕：这是一节，这一大条分成三节。头一节，他说太阳病呀，在八九天的时候，真正的伤寒病在八九天的时候就是一个关口。这个病好也在这个时候，危险期过去了。可是病的恶化也在这个时候，这

个八九天是这么一个阶段，在伤寒病里。假如这个病有了这么一种变化，“如疟状”，发疟疾大家都知道，定时发作，“发热恶寒”，有定时的发热恶寒，而且“热多寒少”。这个表证呀以恶寒为主的，所以我们以后有很多的这个解（释）的段落，（如）“恶寒者表未解”。如果这个病要是去表，这个恶寒就要少，没有表证的就不恶寒。所以每每的这个表证呀，我们以恶寒的轻重多少而来验证表证之进退有无。那么这一节就说明这个，这个人变成现在这么一个情形，定时发寒热，可是热多寒少，是不是这个病转变了呢？他底下又接着说了，“其人不呕”，他要转变这个少阳病呀，心烦喜呕，他非要呕不可，这个人呕，证明他没传少阳。“清便欲自可”，清便欲自可就是大小便正常，二便正常了，也没传阳明。阳明，大便燥结，小便黄赤，也没有。所以这个病既没传少阳，又没传阳明，只是一天二三度发，就是二三次发寒热，而且热多寒少，这么一个病。

看看脉吧，“脉微缓者”。这个微缓不是又微又缓，是微见其缓，微微的缓，脉不数急，脉也不紧，见着他缓弱，这个缓弱说明这个病现在平静。咱们开始就讲“脉若静者为不传也，脉数急者为传也”。脉数急说明这个病正在发展变化，脉微见其缓弱，说明这个邪已经衰了。可是这个病现在来说是没有好的，他还是发热恶寒如疟状嘛，而且热还偏多一点，但是这个热多脉应该快呀，应该数急，脉反倒微缓，挺缓弱，意思也就是当然不是快了。那么根据这个脉与这个热多寒少比较看，这个热不要紧的，不久将好了。因为这个脉见到缓弱，是邪衰的一种反应。是的，尤其这个急性病，一来这个脉来都数急呀，而且应手带紧，这个紧脉不是好现象。假若这个脉也不紧了，缓弱了，也不快了，那么这个病也就停止了往前进展。尤其缓弱，邪气已衰了，这个病就“不了了”了，言外就是说这个病不治也可以放心自愈。这是头一段。

这又是一段。他说这个太阳病得个八九日，虽然是如疟状，一天

两天都发，那么他不是热多寒少，他是只恶寒，一味的恶寒。而脉微，脉微是不足的脉了，这个脉微者为亡阳啊，他是没津液呀，这是表里俱衰啊。这段也可以这么讲，就是太阳病得之八九日，没有如症状以下这些情况，太阳病得之八九日，这个人是只恶寒而脉微，这是表里俱虚，陷于阴寒症状。那么这个时候是不能够再发汗、再吐、再下了。这么讲也可以，没有这个如症状，不搁到上头。总而言之，他这第二段不是这一段所论述要说的，主题在下面。头一段所说的，欲愈者如症状，一日二三度，发寒热，热多寒少，而且脉微见其缓弱，这是邪衰病有欲愈之兆，言外不治也可以。这一段说到八九日的时候，脉微而恶寒。无热而恶寒，这脉已深陷于里，阴寒的一种证候，所以他叫表里俱虚，不可再发汗、再吐、再下了。怎么办呢？就是用温补的法子了，用什么药呀？随证治之，后头他有，后头有的是，治这个病，现在不是主要治这个。那么底下就是第三段了。

这个又反过来到头前了，把他太阳病八九日……。。。。（音频缺失）（第四讲）。那么那个欲愈，他不会颜面赤红啊。他说如果这个人面色反有热色，热色就是红啊，面色缘缘正赤啊，要是这样的话这个病还不是要好的。为什么呢？这个古人有个名称，叫做拂郁在面，阳气拂郁在表嘛。所以这还是表没解的一种证候，表热它出不来，所以人这个脸发红。人不得小汗出，要一得小汗出就好了。而且病人的身体呀发痒，要出汗它出不来，那么水分含在皮肤里头，人发痒，你问问他准痒。那么这样子所以他用小发汗方，宜桂枝麻黄各半汤主之。为什么用桂枝麻黄各半汤呢？你看看啊，这是桂枝麻黄汤的合方，各取小量，都是各取 1/3，量极小。为什么呢？你看那个证候我给你们分析分析你们就明白了。所以这个合方啊，是两个病合并到一起，你得有个认识。你看这段说的很好，如症状，那就是定时发寒热，不过这个他写到头前了，后头有这个，说是啊，人脏无他病，时发热汗出者桂枝汤主之，时发热汗出，时发热就是定时发热，而汗出，这就是桂

枝汤证。古人叫营卫不调啊，营卫不谐啊。那么这一段你们看一看，如症状，就是定时发寒热了，定时发寒热他像桂枝汤证又不是整个桂枝汤证，定时发热汗出才是桂枝汤证，他这个虽然定时发热多，寒是少，但是他不汗出，桂枝汤证有一半，那一半不汗出是什么呀，不得小汗出，出不了汗，麻黄汤证的一半嘛，是不是。所以我们对于这个合方啊，你对这个方证不熟啊，你就是搞不清楚。他这个既有桂枝汤证时发热这么一个问题在里头，可是不完全是桂枝汤证，完全是桂枝汤证就不用麻黄汤了，他又有不得小汗出这么一种麻黄汤证，可是麻黄汤他只能发汗，它不能够治时发热，如症状它不能治。所以这两个方证啊都具备都不全，所以他是合方治疗。但是这个病非常的轻，一日二三度发寒热而且脉微缓，这是欲愈的一种情况。就由于拂郁在表，表还没完全解，得个小汗就能解，所以这个方剂药用的非常的轻。你们看一看桂枝一两十六株（去皮），一两十六株啊再拿三除，才多点啊，这都是古制啊，一两是二十四株，六株是一分，一两是四分，这是古时候度量衡的制度。不到二两，二十四株一两，十六株。底下都一样了芍药、生姜、甘草、麻黄各一两，你看一两拿三除，古制才三钱挂点零，古制一两合现在三钱，那很轻了，它也是三付呀，才几分的药，很轻很轻了。再看看底下的煎服法，“以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫”，这是一个定则，煎药的法则，麻黄这个药啊，它这个沫子缠脑袋，所以煎麻黄都要先煮一两开，把沫子撇一撇，这现在还是应该遵守的，把那沫子撇了。“内诸药”，再把其他的药搁里头，煮取一升八合。他古人呐，他是量病用药，他不但药量轻，吃的也轻，一升八合他均了三次吃，每次吃六合，不像咱们头前吃桂枝汤，一回吃一升，这地方咱们在临床上都要注意了，这个轻病不但药量轻，而且每次也得少，所以这是个方法，在这个方子上要注意了。病重，量重，要多吃；病轻，量小，要少用。温服六合，三六一十八。“本云桂枝汤三合，麻黄汤三合”，这个方子本来是这么说的桂枝汤三合，

麻黄汤三合并为六合，他把桂枝汤也煎出来，麻黄汤也煎出来，这个里头倒三合，那个里头倒三合，三合就是 $1/3$ 了，一升拿出三合不就是 $1/3$ 吗，然后两个搁到一起，不就是六合了嘛，十合为一升，顿服，源起呀这个方剂呀是这么注明的。那么现在呢？张仲景就把它放到一个方子里了，它就是这个分量了。那么这个方子是小发汗的方，这个发汗很轻很轻的。底下林艺他们给算这个分量，根据源起是怎么搁的，但是这两个方子的比例数，还是搁 $1/3$ ，两个都是各半，等量，各取本方的多少。我们现在来用呢，也就是把桂枝汤取 $1/3$ ，麻黄汤取 $1/3$ ，但是相重的药不要加在一起，你像甘草吧，桂枝汤有甘草，麻黄汤也有甘草，把两个药加起来也不行，合到一起，这个共有的药味呀，就根据大量的用，那不同的呢，就按前面的合法，如果 $1/3$ 取 $1/3$ 的量就行。你像桂枝、麻黄原先都是三钱呐，各取一钱就行了。再少你还可以再轻取，那也不是固定的，研究这个东西也是，它不是固定的。我们在临床时呢，根据病的情况，我们还可以少取，就是麻黄一钱，也没有大发汗的，这不足以大发汗。

李冠杰：“太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三度发”。下边是注：“脉微缓者，为欲愈也。脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗、更下、更吐也。面色反有热色者，未欲解也”，正文：“以其不得少汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤”。这一条的正文在《康平本》里边是顶格的，中间又加了篇幅相当大的一个嵌注，还有这一条《康平本》和《宋本》有一字之差，就是“以其不得少汗出”，《宋本》是“以其不得小汗出”。这个倒没有什么原则问题，像这一类的“小”和“少”的差别，在康宋二本之间有好几处这样的差别，不影响我们的理解。

我们作一个直译，为了能够正确的理解原文，从直译我们就应该把原文和那个嵌注的注解文字分开来，包括解读也应该分开来。因为它不是出自一人之手，论述的对像不十分一样，就说它有区别。先把

原文作一个直译：患太阳病，已有八九天的时间，如同疟疾的状态，表现为发热恶寒，而且发热重于恶寒，一天发作二三次，病人不呕，二便基本正常，此时病人可能会有身痒的症状，这是由于本来应该得少汗出而解，但却不能的缘故，对此应用桂枝麻黄各半汤治疗。嵌注文字直译应该是这样的：如果在一日二三度发所论述的这么一种状态下，病人的脉出现微缓的，是病要解除的征像；如果此时脉微而恶寒的，则说明为表里俱虚，所以不可再以发汗、泄下、或又吐的方法来治疗；如果面色反有热色的，说明不得自愈，就是得不到自愈。

现在作了直译以后大家就看出来了，在见到《康平本》之前，没有任何一个人会想到这么去理解这个条文，也没有人会想到这中间会有嵌注。但是当我们看到《康平本》以后，我们会发现确实它不是一类的文字。大家再回过头来看看原文，看看《康平本》的样子，把那个嵌注拿出去，这是非常完整的一条文字，前后非常通顺，而且叙述得也非常清晰。嵌注这一块内容，它说得是另外的问题，在正文基础上衍生出来的问题。我们下边在解读的过程当中，慢慢地都一点一点地把它化解开来。

先来看看原文，“太阳病”，理论上说它应该既包括阳性的表实证，也包括阳性的表虚证。

下边“得之八九日”，就等于说病程已经比较长了。这个病程比较长，他就容易处在一个要么发展成其他的疾病，也就是说病程加重，人体的抵抗力抗不过疾病的致病因素；另一种情况呢，就是他有可能自愈。用今天的话说，这人得了感冒以后，一得得了七八天、八九天，就有可能快到自己就会好了，或者可能会变成别的病，就是处在这种关口的可能性非常大。我们从这儿还能看出另一个问题，就是王叔和加进去的文字，跟经方的理论不相衔接。像他说的那个六日愈、七日愈的问题，那个传变的问题，都是过于机械。你看这儿就出来了，特意说了是八、九日，而不是一个准确的日子。实际上在临床当中，

有的表证可能时间还要长，这完全有可能的。所以说没有那样的规律，把那个固定的天数当作人体疾病的规律总结出来，就是犯了机械化的错误。

这个“如疟状”，主要是想说一个什么问题啊？就是说发热恶寒呈现一种阵发性的特点，用现在的话说是一阵一阵的。同时“如疟状”的背后还有另一层意思，尽管一阵一阵地发寒热，但是它不是疟疾。

这个“热多寒少”，刚才我们直译当中就说了，应该把它理解成什么？就是发热比恶寒要重，历史上大部分注家都这样的理解。我们应该客观地说，这个发热恶寒就是热多寒少。按这个方剂的适应症来说，它的病理，发热也好恶寒也好，都不是特别的重，至少不会发高烧，因为这是一种轻症。

“其人不呕”。像这种表述方式，在经方的理论里边有的是。这个不呕，不要仅局限于它的字面意思，它本意是想说这个人没有少阳证，所以就用了个“不呕”。可能是像这一类的情况，如果有了少阳证以后，呕的机会比较多。如果说往来寒热的话，他本身就又有阵发性的寒热，所以很难去用往来寒热来鉴别。这个“不呕”相对也是一个比较典型的症状，在其他的地方也有说“不呕”的情况，“不呕”本身就是一个没有的症状。为什么要说呢？就是想跟你说这儿没有少阳证。如果说这个人特别不愿意吃饭，精神特别不好，那我们是不是也应该把它理解成少阳证？完全可以的。有口苦行不行？也行。我们只要是理解了它的意思，在临床当中没有呕的症状。那他有其他的少阳证的症状可以吗？只要有，“但见一证便是”。

这个“清便欲自可”，就是说也没有明显的里证。实际上这个地方就是想跟我们说没有阳明证。那当然这里边也会包括了像二便正常，包括一些大便不干、大便正常，小便正常，这个正常同时也可以排除大便溏泻，应该排除在里边的证，就总地说没有里证。

既没有半表半里证也没有里证，那么它就是一个表证。表证具体

到什么程度呢？一日二三度发，一天要发个两次、三次。这也不是一个非常准确的频率，本身有一个模糊概念。那么像这样的情况，又是一个表证，又会出现发热恶寒、热多寒少的情况，而且既没有少阳病，也没有阳明病。这是什么原因造成的呢？他解释了这就是“以其不得小汗出”，本来这个人如果能出一点小汗的话，他的病就应该好了。但是却出不来，没有能力达到那个状态。

这个“不得小汗出”。特别是像这个顶格的条文，解释病理的文字一般比较少，它是只给你说症状，然后说治法，让你自己在里边去体悟。我们从学会桂枝汤，一直到现在已经跟麻黄汤的一个合方这儿，古人把这个疾病一层层的，光一个表证就分了好多种，后边还有一些表证里掺杂水证的、里热的。说明古人在这方面总结得非常详细，实际上也理解得非常的准确，但是却很少去论述。这个“以其不得小汗出”，这一下就把这一条病理的解释做了非常概括的总结。你看这是什么样的人？这个人得了表证，表证的症状已经明显的减轻了。怎么看出来明显减轻了？他不是一直在发热恶寒，是有时有响的，一天发生两三次。同时再进一步的诊断，没有少阳病，也没有阳明病，也没有里证，也没有半表半里证。这个时候为什么表证老不好呢？那只有一种可能性，如果人体再强一点，自己就能出一点汗好了，如果人体再弱一点呢，可能就是一个桂枝汤证。但这个人体此时恰恰停留在想出汗又出不来的这种状态，所以就跟你讲“以其不得小汗出”。

那么，有这种病理状态以后呢，这个“身必痒”应该把字面的意思理解成什么？有可能出现身痒，不一定真的每个这样的病人都身痒，因为其他地方这个“必”字，大部分应该都去这么理解。把这个症状放在“不得小汗出”后边，也就是说不是皮肤病的身痒。这个身痒是什么？是因为人体要出汗，但是又达不到出汗的这种状态，而且还有出汗的这种趋势。我在这儿跟大家挺形象地说一个生活当中常见的啊，比如一个冬天差不多没有洗澡，如果有了机会洗一个热水澡，

你泡在热水里慢慢地随着温度的升高，快要出汗的时候，你感觉到就是一种身不但痒，严重的时候汗毛孔像针扎的一样，这个地方疼一下，那个地方疼一下，又痒又疼的感觉。实际上这就是那个想出汗不出来，体表下边又有一些水分压迫汗毛孔发痒发痛，严重的就会痛的那种感觉。但是又到不了麻黄汤的那种程度，所以说它就出现这么一种既达不到表实的那种程度，又达不到表虚汗出的那种程度。以上这是原文的内容。

我们再来看看嵌注的内容，嵌注我前边跟大家说过，很难具体地说是谁写的，没法做一个简单的定义。但是，这个嵌注的作者对原文的理解是比较到位的，嵌注说了三种情况：

第一种情况就是说“一日二三度发”的，就是发热恶寒、热多寒少这类的情况一日二三度发，如果出现“脉微缓”，这个微缓是指脉有了轻微的缓弱的脉象，而不是又微又缓，不是说脉又沉又细，非常微，或者脉很细的那个样子。因为它不是这个病，脉还是浮中已经开始有缓和之像了，出现这种情况的就是人体有欲愈的那种趋势了。“欲愈”的言外之意就是像这种情况就不用治了，很快就会自己好了，这是一种可以自愈的情况。

第二种情况呢，如果“脉微而恶寒”，这个地方就写得就非常明确了，文字比较准确，就是说脉又微又细而且恶寒。这个时候有可能是陷入阴证了，有可能就是桂枝加附子汤证，所以说像这样的情况已经是有可能成了少阴病了，少阴病就不能再用攻法简单地去发汗了。这儿的发汗不是指的桂枝汤或者桂枝加附子汤，它这儿的发汗是指的麻黄汤而言。既不能发汗，泻下和吐就更不行了，也就是说不应该用一些攻法，这是第二种情况。这个虽然也可能有上边那些基本的特征，像发热恶寒、热多寒少啊，但是如果脉象出现这样的话，它是病情比较严重的一种情况了，你要小心。

那么还有一种情况就是这个方剂的本证。这个方子除了身痒和前

边那些症状以外，这个作者在临床当中发现，患者还经常会出现脸部有时一阵阵发热，实际上热多寒少应该就包括了这一类情况。这种情况就是“未欲解”，它自己好不了，好不了就得用药。这里的文字之间衔接的也非常好，原因就是正文里解释的原因，方剂就是正文里边给出的方剂，这样就行了。所以说这个嵌注呢，应该也是这个作者在临床中积累的一些经验。

我们回顾一下这一条。这一条实际上论述的是一种阳性表证，而且又是虚实错杂的这么一种病理状态，这一点非常重要。因为我前边跟大家介绍过经方辨证体系，以后还会跟大家说，这个经方辨证体系啊，不是说说这么一下就行了的。

上一次有一个朋友过来，我把经方辨证体系的关系写在纸上，那我划了几条线。我们看看如果这个方剂划线的话，上边是疾病类型：表、半表半里、里、水证、血证、气证六大项；下边是疾病性质六大项：阴、阳、寒、热、虚、实。上边的疾病类型和下边的疾病性质之间，如果连线的话，这个方剂该怎么连呢？它首先肯定是表证了，刚才说了一旦要脉微，一味恶寒的，那就是陷入阴证了，这个方剂的适应症不是，它是一个阳性证，那么上面表证和下边的阳字之间应该划上一条关系线；另外，表证还要和虚证划一条线，因为里边有桂枝汤嘛，它要是不虚就用不着桂枝汤了，待会我们还要说一下；另外表证和实证之间也还要划一条线，因为它是想出汗出不来，还有某种表实的因素存在。所以这是一个虚实错杂的方剂，既有虚的成分，又有实的成分。以后在经方的辨证过程中，经常会跟大家说这样的东西，如果慢慢掌握了以后啊，你就会发现在临床当中这些东西比用脏腑辨证更贴近事物的本来面目，而且掌握了这种辨证体系之后再用经方，越用你就感觉经方越好，退一万步说，你发生用错方的机会会很少。

我们再看一看方剂，这个方剂《宋本》说得非常的详细，这个剂量大家需要仔细看一看。很多人看了胡希恕的讲座以后，就认为两个

方剂的合方就是把相重的药味取大量，比如这个方剂里的桂枝，就用桂枝量大的就行了。实际上它这个书上不是，这个方剂我们从头到尾看一遍，你会发现方剂的方后注里写得很明白，它是熬好的药液，取一剂桂枝汤的三分之一，另外再取一剂麻黄汤的三分之一，把它们合到一块，这样实际上就形成了一个小剂量。实际在后来张仲景把它变通了，就把药加到一块形成了一个新的方子。形成的新方子的药量实际是各取原方的三分之一，但是药味之间是一个简单地相加，桂枝汤里边有桂枝，麻黄汤里也有桂枝，把这两个量各取三分之一加到一块，是一个和。

这儿呢就带出另一个问题来。我们现在临床当中合方应该怎么合法呢？我们从读经方原文的角度说，首选应该是简单地相加；其次就是把相同的药味取量大的。比方说两个方子合到一块，哪一个方子的相同的药量大，你就取哪一个药量也可以。经方里有好多这样的方剂，最典型的就是柴胡桂枝汤，柴胡桂枝汤实际上就是小柴胡汤和桂枝汤的合方。但是它的药量不是简单地相加，如果简单相加的话，像大枣、生姜的量就要大一倍，实际就是在桂枝汤的基础上，相重的药就取了一个数，然后呢就加上桂枝和芍药。但是它总量降低了，这也值得我们研究。

我们应该这么体悟啊，就是说古人这个用药量几乎用到最大的极限了，按普遍的中等水平来说，就是用量偏大了，所以合方以后药量要减的。

但是，这两种方法你总要取其一，到底是用简单相加的方法，还是用那个取一个最大量的方法呢？不少人提这个问题。因为这两个方法古人实际上都在使用，如果用机械的眼光来看，你会觉得无所适从了，不知道该怎么弄了。但是要稍微换一换角度，你会发现这实际上是个活法，古人没有用一个特定的方式把你局限住，你本身就可以辨证。那么我们变通的依据是什么呢？你只要是把经方弄得熟了，就自

然会从里边发现这种规律。纸上谈兵都可以，比如把小柴胡汤和半夏厚朴汤合一合，你会发现有相同的药也有不同的药，不同的药是什么，治的是什麼病？患者这个症状明显的话，这种药就可以加重一些。我经常会用一个让人感觉到很奇特的合方，就是小柴胡汤合上半夏泻心汤。我合就非常简单了，有现成的小柴胡汤的粉剂，也有半夏泻心汤的粉剂，如果我想要一比一的话呢，就各取一克合到一块这就是两克。那么它治什么呢？它治既有口苦而且肚子又有点不太舒服，轻微的有点肠鸣，有点肠胃不太好，大便呢也不是特别得好。像这样的人让他吃这个合方，就比单纯地服其中的一个方子效果要好。我现在是用的简单相加的方法，如果相重的药只取一个量的话，你会发现加的药很少，就是小柴胡汤加干姜和黄连；如果简单相加和小柴胡汤加上干姜黄连有什么区别吗？有的。区别在哪呢？柴胡的量这是最明显的，如果简单相加的话，相当于柴胡的量少了；要在小柴胡汤方剂的基础上加上干姜、黄连，相比之下柴胡的量还是不小（当然指的是说它比原方是小一点但小的幅度有限）。所以说它对的是什麼？对的那个柴胡证不是特别明显的。这不就有了嘛！如果柴胡证特别明显又往来寒热又胸胁苦满的，有这种情况的话你就用小柴胡汤，又伴有一些肠胃方面的半夏泻心汤证，你用小柴胡汤加上干姜、黄连还是比较好。所以说这里关键是你对经方的理解到什么程度，你要理解好了，这个变通都是活法。

我在这跟大家举个例子。上次有个老师在讲用小青龙汤合四逆汤。我马上想到一个问题，如果说小青龙汤合四逆汤的话，不如说小青龙汤和麻黄附子细辛汤。为什么？这里边也有四逆汤，但是病人绝对没有明显的四逆汤证，如果有明显的四逆汤证的话，就用不着这么多解表药了，而且还有那么多祛水的药。换一个角度去看方剂和合方的话，实际上就是小青龙汤加附子，那么这里边就看你怎么去理解。当然要真的有四逆汤证的话，那个干姜、附子、甘草的量得加大；如

果真要是小青龙汤加一点附子就去治明显的四逆汤证，恐怕是疗效不会好；如果有麻黄附子细辛汤证，实际上就是小青龙汤陷阴证了，这样更好理解一些。

关于那个方剂的合方，林亿在后头加了一个注解，大家看一看，抠一抠挺有意思，他说古人弄得非常严谨。

大阳病、初服桂枝汤、反烦不解者、先刺、风池风府·却与桂枝汤则愈、（24）

胡希恕：这种事情不常遭遇的，本来他是桂枝汤证，开始吃桂枝汤的时候啊，不但病没好，反烦不解。这个桂枝汤证不是不烦，烦得并不厉害，吃了桂枝汤了，汗出身和，应该不烦了。而这里反起了相反的作用，反烦而表又不解。这个不是桂枝汤有了毛病，是邪盛气滞，咱们说肌不和了，在肌肉这一层啊比较实，所以这个药力受阻，那么这个时候呢可以用针灸刺风池风府。辅助治疗的这个方法，这也不可不知的。本来这个病人他是桂枝汤证，我们也给他用的桂枝汤，他反出了相反的作用，你要不知道这个作用就不好解决了，知道这个问题，哎！用针灸，刺完风池风府再用桂枝汤那就得好了。那么这种事在临床上我一生都没遭遇到，但是古人这么说就可能会有这种情形，咱们也不可不知的。

李冠杰：这条也是顶格条文。其中加了“风池风府”四个字的旁注。

直译一下：太阳病，第一次服桂枝汤后，反而出现烦不得解除的情况，应该先刺风池和风府，然后再以桂枝汤治疗即可痊愈。

这条相对比较容易理解，相关的内容也来解读一下：

这里的“太阳病”，仅仅指的是太阳中风证。上一条说的那个太阳病，理论上它可既包括表实证也包括表虚证，这条不包括表实证，就是一个太阳中风表虚证。

这个“初服”，桂枝汤一剂分三服的，初服指的就是第一次喝桂枝汤。

喝了反倒是出现“烦不解”，我们应该理解成这就是服了桂枝汤以后的瞑眩反应，出现这样的瞑眩反应就是因为病情比较重。前边那一条论述的病情是比较轻的，这一条论述的虽然是个桂枝汤证，但是病情比较重。所以喝了桂枝汤以后，反倒出现更烦了。

原文里实际上就两个字“先刺”，但没有说刺哪儿。我们应该怎么去理解？在当时像这一类的疾病，很可能像针刺风池、风府这两个穴位是一种常规的治疗方法，所以就没必要说的那么详细。后人在解读的时候发现写的太笼统，就给了具体的两个穴位。我们这个群里边，参加我们学习的有很多是搞针灸的，我挺佩服这些同仁的精神。我觉得针灸是一种很好的治病方法，但是研究方向上自始至终有一点问题。它不像经方体系这么完整、完美，研究的这么到位。所以期待着搞针灸的同胞们，有朝一日能把所有的病也跟经方这样，弄一套比较完整的辨证体系，在辨证体系里，每一种情况都有一套比较完整的治疗方案。

比如小青龙汤是个表实证。假设说风池风府也能治疗表实证，有表实证，风池风府这两个穴位有了；同时又有里虚寒又有水饮，我们用什么穴位能解决呢？大家可能会说这个太牵强了，搞针灸的是用脏腑经络来辨证的，跟这不是一个体系，不要这么去想。真理只有一个，现在针灸形成了一种什么局面？现在针灸治的都是急性病、疼痛的病，像一些慢性病、内科病用到的机会不多。而且不是说完全没有效，但是疗效不够巩固。为什么？就是因为同样都是研究人体，怎么可能会出现两套理论嘛！不太可能。我跟大家经常说的那两个肝炎病例，肝炎哪来的？不是现代医学定的名吗？两个肝炎一个用小柴胡汤治好了，一个用吴茱萸汤治好了，两者是完全不同的两种肝炎，尽管在现代医学都可能叫做乙肝，但这是两种完全不同的病。所以从这个意

义上说，现代医学也走了弯路。针灸里边也有这种情况，如果针灸也能用这样的方式来治病的话，我想针灸的效果绝对不会比吃药差，而且副作用要小得多。这个在实践当中已经反复证明了，但现在就是没有这么一套体系。针灸里边近期还在出现一套新的穴位，比如董氏针灸也就是近代的事，疗效也那么样的好。说明以前的针灸还没有发现这一部分吧。希望有志的人啊，能够去探索探索。

前两天有一个上海的朋友，跟我说了某某人的一套新的医学，仅凭脉来治病，而且用药非常少，不超过三十味药，而且特别有效，当时吃药一会儿就感觉非常有效。我对他这种方式 and 理念很感兴趣，但是这种方式不好。不好在哪呢？大家换个角度想这个问题，假设我现在病了，在上海我的朋友是个好中医，我跟他打电话，告诉他我现在怎么怎么不舒服，我把症状说得再清楚再好，恐怕他也是在一个固定方剂的基础上加加减减，他积累了这么多的经验，我见过这样的病人，我说疗效时间长了，你就会发现问题。结果呢，我这朋友后来就出去到别的地方考察，他就跟我说了一种现象：现在有些中医找一个地方开会，找一些病人当场用针灸治疗，非常有效，不管什么病针下去马上就觉得好了。但是我的朋友因为我跟他说了以后，他就多了一个心眼，后来他就去跟踪这些病人。结果发现，他们是当时用针灸来开路，因为你的症状马上感觉舒服了，然后他就卖给你药，他的药是不管用了，针灸的疗效也就仅能维持一两天。我觉得如果费这么大的心思研究一套东西去骗人的话，还不如实实在在去搞一点真正的研究。这儿说的稍微远一点了。

这个地方说到了一个“冥眩”反应的问题。它本身就是一个桂枝汤证，这个条文最后是“却与桂枝汤则愈”，就是说用桂枝汤又把这个病治好了。说明前边那个太阳病应该是一个桂枝汤证，而且用桂枝汤也没有用错。本身就是一个表虚证桂枝汤证，为什么吃了桂枝汤会烦的更厉害了呢？“反烦不解”呢？这就是中医的一个比较特殊的瞑

眩反应的问题。

关于暝眩反应，我跟大家说一个医案，今天这个孩子的母亲给我说孩子彻底好了。一个十岁的小女孩，她一年半以前体质比较弱老感冒，就输液，输来输去就不太好，她母亲知道我这儿，就来我这看病。我根据她当时的情况给了小柴胡汤，吃了以后，晚上十点多她母亲就给我打电话说孩子发烧了，我告诉她这是药对症了，她烧过去以后肯定会好。她说孩子烧得很厉害，快到 40°C 了，我就跟她解释发烧是人体抵抗力高了以后，是它本身抗病的一个过程。但是她说：我不能看着孩子这样发烧，你让我看到孩子这么烧下去，我不行。我说：那你现在就带着她去输液，输上马上就好，好了以后就不要再输了，后边我再给她慢慢地拿中药治，用药量少一点可能就会缓和一些，不一定发这么高的高烧了。到第二天她跟我说，实际上没去输液，她两口子商量用酒精棉球给孩子把腋下、大腿根擦一擦，散散热，他们想仿效了西医的做法。结果掀开被子一摸身上潮乎乎的，孩子已经出汗了，就别擦了。第二天她给我说，孩子昨天晚上到了夜里 12 点多出了一点汗，慢慢体温下来就好了。后来小孩又吃了几天小柴胡汤就好了，之后一年多没闹什么问题。

最近这孩子又开始有点发烧、咳嗽，觉得嗓子里老觉得有痰一样吐不出来，吃饭也不好，孩子说有点口苦。我就给她小柴胡汤合上半夏厚朴汤。后来她母亲又给我说孩子发烧挺厉害，烧到 39°C ，她说给孩子吃了退烧药，现在退下去了。我说：你上一次又不是不知道，为什么给她吃退烧药啊？我说这个药你拿回去吃，孩子肯定还会发烧。她说那烧就烧吧，她因为有前一次经验，就带着药回去了。第二天她打电话来告诉我说孩子昨天晚上烧到 39°C 多，到了下半夜的 4 点多出了点汗，彻底体温退了。第二天上午她又带着孩子到我这儿，说是体温又高到 38.5°C ，我说这是正常的。后来就继续吃药，到昨天是第三天，孩子开始腹泻。我问为什么腹泻呢？她说孩子奶奶老让

她吃雪糕。我说这孩子有病，没有病也不能吃雪糕，就又给了她十几克理中汤。后来她给我打电话说，吃了两次肚子就没事了，小柴胡汤和半夏厚朴汤也没了，还稍微有一点咳嗽。我说不要管了，理中汤让孩子接着喝。孩子因为理中汤喝不下去，我让她装胶囊，一次吃三个到四个，吃了两次就好了，我说你再让她吃两天。今天她来我这儿跟我说孩子彻底好了，咳嗽也好了。我说以后再也别给孩子吃雪糕了。

大家想想啊！我们体温三十六七度，里边可能还要高一点，体温这么高，雪糕这个冰块在嘴里化开以后，大概那个凉水就是十来度的样子，而且夏天的环境温度又这么高，对人体非常不适应。吃下去以后下温度骤然这么低，胃肠就不蠕动了，实际上就偏于寒了，厉害了不就下利清谷嘛？所以说小孩子不管天多热都没必要去吃。假如说要在 100 年以前的话，夏季你到哪去吃冰块啊。所以人吃冰镇的东西是不合理的，人没法去习惯这样的环境。

跟大家讨论一个医案，是这周碰到一个比较典型的手足口病。现在手足口病被炒得非常热，说得也挺吓人，因为有死亡的病人，所以凡是自己孩子得了这个病的家长都非常害怕。因此中医治疗手足口病的机会就非常少，因为现在很少有家长自己的孩子得了这病会想到让中医来治。那么我治的这个孩子，在这种环境下怎么会找到我给这个孩子治病呢？这个孩子大概有将近一年的时间了，小孩子得病大部分就是感冒咳嗽，只要有这一类的情况他就在我这里治疗。他为什么在这里吃药呢？这个孩子家里人和亲戚都在我这里治病。等于说他这个家庭就是比较相信中医。其实以前他这个家庭在我这里看病最早是他的一个表叔，今年十岁，他来这儿看病的时候每个月都得输液，他母亲就觉得这输到什么时候算个头呢？实际也没有什么大病，就是感冒发烧。输液以后好了，过不了一两个月又发病了再去输液。老百姓通过宣传什么的也知道一些输液、输抗生素有很大的副作用，到后来她就听别人说，来我这里看病，而且她感觉效果非常好。后来他家里的

人都来看病，什么样的病都有，基本上都治好了，所以他们就比较相信。

我把这个三岁孩子的病历拷过来了，原汁原味地跟大家说一说，最后再说一些相关的认识。他首次因为手足口病来是5月23号，当时的病历记载：来诊，两手掌内侧和两脚掌两侧起红色的痘疹多处。就是说的前几天手脚上就有了，今天口腔内也出现了，可以认定是手足口病。最近几天这个孩子食欲不好，当时测体温没有明显的体温增高，但是用手摸会感觉有一点热。昨天晚上出现哭闹，这几天常见精神不好、犯困，舌质比较淡，舌尖有一点红，舌苔是薄白，脉弦滑，流鼻涕，轻微的咳嗽，可是非常轻。我问的大便，这是个很重要的事，当时的家长说大便没有注意，这少了一项比较重要的指标。我记得当时孩子还有偶尔干呕、欲呕的情况。这样我就给他小柴胡汤20克左右，因为病人离我这儿很近，我上下班正好路过他们住的地方，就给他的量比较少。让他一天服两次，一次不到3克的样子。我就嘱咐他的家长注意孩子的大便，如果孩子大便稀马上告诉我。到了下午就来电话说孩子大便明显地稀，我说你赶紧过来拿药，又给了他20克左右的理中汤。小柴胡汤是早饭以后和晚饭以后吃，让他午饭以后加一次理中汤，这是23号的情况。

24号，就是第二天早晨，他家长打电话来说手和脚上的痘疹没有明显的变化，也就是说没有再严重、没有再发展，但是他的下巴颏附近又起了很多，其他的没有明显的变化。我告诉他接着让孩子吃药。到了下午孩子大便基本上正常了，但是最后还多少的有一点点溏，后来说是又解了一次大便，大便里看着好像是有消化不太好的东西。我就告诉他，理中汤不要中午吃了，半上午和半下午，一天再服两次。同时他说孩子明显地看着有精神不佳，显得比较疲倦，睡眠增多，而且躺下一会就睡着了，嘴里长得那些痘疹，看着有时候孩子要难受，自己就去抠嘴，并且因此而哭闹不太吃饭，情况就是这样。然后我想

了想告诉他，这个时候孩子如果吃饭的话，因为嘴疼他肯定不愿意吃饭，你就给孩子多喝牛奶，这是 24 号。

25 号早晨他家长来电话说，孩子昨天晚上食欲明显有增加了，吃了汉堡包的肉馅，面包没有吃，吃了东西以后又喝了一盒牛奶。这说明孩子有食欲了，但是嘴痛，不愿意吃需要嚼得时间稍长一点的东西。大便一天两次，好像这一天到了比较晚的时候还没有解，睡眠还很好，口腔里面的痘疹已经开始看出有所减轻了。吃饭的时候疼痛感呢比以前也轻了，也没有那么痛苦了，再也没有因此哭啊闹啊。两个手上的痘疹基本上开始消失，脚上还剩下几个。但是又发现在口腔里面有一处不是痘疹了，是溃疡面，就是说出现了口腔溃疡。孩子的食欲，这一天里头下午和早上比，明显地看出食欲好很多了，这是 25 号。

去年我对这个病就比较关注。曾经有一个孩子我都把药给他弄到嘴边上了，结果没有喂下去，后来还是输了液了。26 号我电话回访，他家长第一句话就说：孩子没事了，除了看着吃饭的时候，不一定哪一口还看着有点痛以外，其他的什么症状都不明显了。大便初头还可以，但是后边还略偏溏。这样，我就让他理中汤改成午饭以后吃一次。到了大概晚饭前后的时候，这个家长给我打电话说，我们家的孩子今天玩疯了，他奶奶带他出去玩，叫都叫不回来，精力精神都明显地好转了。

27 号，手和脚上的痘疹基本上完全消失了。但是口腔里边又出现了一处的溃疡面，等于说出现了两处口腔溃疡，大便仍然是初头可，后边略微有点溏。这个时候我嘱咐他家长听听孩子有没有肠鸣的情况，就是肚子是不是咕噜，但是那个家长也比较忙，看着孩子差不多快好了，也不太注意。后来我就给了他甘草泻心汤，放得甘草比较多一些。甘草 10 克，干姜 3 克，半夏 3 克，黄芩 3 克，人参 3 克，大枣 3 克，黄连 1 克。告诉他一天服两次，把小柴胡汤呢，改成中

午服。

到了 28 号，也就是说昨天，我又打电话问，说是昨天晚上孩子食欲非常得好，以至于到最后家长就不敢让他吃了，他以前没吃过那么多，而且他那个口腔溃疡明显地减轻了，能够正常吃饭了。我告诉他把药要不就这样服一天，要不就把小柴胡汤和甘草泻心汤合到一块，一天服两次就可以了。这是 28 号的早晨问的，到了下午接近晚上又跟我联系，说是中午孩子奶奶给他煮的面条，就是白水煮的面条，什么菜还没来得及放，那孩子就哇哇地吃得挺多，观察那个口里面的溃疡面已经很轻微了。

今天，也就是 29 号早晨我又打电话问孩子的口腔溃疡怎么样了？说现在就只剩了一个红底盘了，那个溃疡面发白的地方已经没有了，食欲非常好，玩得也非常好。今天下午又来电话，说是不是应该考虑给他把药停了。因为孩子太能吃了，会不会吃得多把胃撑大了，以后吃成小胖子啊！我告诉他就注意一件事，不要让孩子吃得太多了，太撑会伤到胃。这样基本上这个病就算全好了，我告诉他这个药减量，减到一次就服 1 克到 1.5 克，而且是小柴胡汤合上甘草泻心汤两个方剂。像这个手足口病，基本上就完了。前后从 23 号到 29 号一共是六天的时间，不到一个星期，基本上是一天一个样子。

凡是跟大家说的我的医案啊，都是得有反馈的信息。比方说今天来了一个病人，我觉得辨证辨得特别好，然后方剂用得也非常好，再好我也不会拿到这儿跟大家一块儿讨论，非得拿到患者反馈信息，已经反馈或者别的病人帮我反馈了，有了相应的疗效，我才会告诉大家，免得对大家产生误导。我觉得跟大家交流医案，比如有人今天来诊，口苦咽干，往来寒热，胸胁苦满，我给他小柴胡汤，他喝了几天以后好了，像这样对大家呢可能也没有多大的帮助。所以我尽可能去挑一些有代表性的，能帮助大家疾病的治疗有所启发的。

像上面这个病例就比较典型了，一是这个病被现代医学说得非常

严重，我们当地这段时间得这种病的孩子非常多，据病人反应说，只要是得了这个病，最低的要花费八千以上，多的要花到两万多。现代医学对这个疾病的发病机理一无所知，不知道孩子为什么得病，也没有真正有效的治疗办法。真正落到我手里边治的就这么一个医案，也挺难得的。去年那个，我给孩子把药弄好后没有喂下去的那个，我给的也是小柴胡汤，但是小柴胡汤加石膏，那个孩子发烧，他明显有热。后来我就特别关注这个事，网上曾经有过报道，就是用小柴胡汤加石膏有治好手足口病的记录。再加上这一例就很容易比较，凡是懂经方的人都能很清晰的知道这是一个什么性质的病，尽管它表现得非常特殊，手上脚上起些红的痘疹，嘴里边也起，好像是书上没有记录，但是它没有明显的表证，也没有特别明显的里证。据我接触的病人，它有一个共同的特点，得这个病之前几天，孩子就会食欲不好、精神不好，“默默不欲饮食”嘛！而且常常会出现干呕，甚至呕吐的这种情况，这不就是“心烦喜呕”嘛？胡希恕也有这个经验，小孩子得病发生小柴胡汤证的几率比较多。这几个因素凑在一块，就是我给小柴胡汤的依据。从疗效上看应该说是非常理想，基本上一天一个样子。我们通过这个方剂，就能知道这是一个什么样的疾病呢？按着我们经方病理来说，就是半表半里虚热的情况。

通过这个孩子的治疗，我想到了另一个问题。到了后期他出现了口腔溃疡，我想的是另外一个病例，曾经有一个十五六岁的小男孩得了牛皮癣，后来我给他治了两个多月就基本上好了。就在将要好的时候，在过年的这个期间他又在以前长牛皮癣的那个地方又开始起红点。当时我就觉得他这里有问题，他还在吃着药，药还没有断，前边的差不多都快好了，说明那个药是确实有效的，他又起了这个红点再让他吃这个药，或者再加量就没有意思了。那就找别的原因，后来我问他肚子里头感觉咕噜吗？他说咕噜呀，大便不太好。我问他吃什么东西了吗？他说没有，就说肚子咕噜，而且说得很肯定。后来我就给

他三天的半夏泻心汤。当时半夏泻心汤我也治牛皮癣嘛，但他得有这个证。结果到了七天多他还没来，我碰到孩子的姥爷问怎么着了，他说好了，回去上学去了。这样就联系起来了，手足口病呢它也是皮肤方面起痘疹，而且痘疹将要好的时候又出现了口腔溃疡，又伴随着大便不好，它确实确实就是一个甘草泻心汤证。我们有理由相信，这个病有可能还跟胃肠或者消化道里面的某些不良状态有关系。

这样我们对这个病的性质基本上就变得比较清晰起来。现代医学它会怎样治？还是输液、输抗生素，或者说用激素，那些治疗实际上是不着边际，所以它治不了。咱们用小柴胡汤治什么病啊？它治你心脏、肺脏、肝胆、肾脏的病，甚至包括胰腺方面的病，你得有这个方证的时候，小柴胡汤可以强化五脏六腑。小柴胡汤如果把柴胡去掉，再加一点黄连、干姜，就等于说有了半夏泻心汤或者甘草泻心汤。所以它对某些肠道里面的疾病也有一定效果，但是用它专门来治疗那个半夏泻心汤证，它肯定疗效不好的。

我们再往下延伸，这个病为什么会死孩子？一般在我这儿看病的，都是些疑难的过不去的，在别的地方屡治不好了，才会找到我这个地方来。孩子来我这儿治病的，差不多百分之八十以上的都是以小柴胡汤为基础方的。也就说孩子在发育的时候，五脏六腑发育都不太健全，他容易出现小柴胡汤证。对孩子来说，小柴胡汤证是一种常见病。可以这么说，没有哪一个孩子没得过小柴胡汤证，没得过的恐怕非常少。如果说这样的话，你看手足口病跟经常看到的某些感冒其实是在一种病理状态下出现的，为什么会出现死亡的情况？大家想想啊，这个病有一个很明显的特点，它口腔里边也长痘疹，口腔里边就必然会疼，他疼了就哭闹不吃饭了。我一开始就想到了这一点，我就担心病人吃不下东西去，当时我还是从病理方面考虑，如果吃不下东西，身体抵抗能力就会弱，我药的疗效就会打折扣。所以我就嘱咐家长，吃不下饭去就让孩子喝牛奶，保证他有一定的营养。

后来我在反思这个问题，有的孩子在医院里边治疗为什么死了？就是因为孩子吃不下东西去。大家想一想，这个病用小柴胡汤治好了，说明有半表半里证，胸腹胸腔这一块状态不太好了，另外常常伴有发烧，在医院里治的话还输着液，输抗生素的副作用是公认的，就是降低人体的正气，笼统地说就是降低人体的抵抗力嘛。加上不能吃东西，把嘴给封住了，像小孩子这样稚嫩的身体，撑不了几天，成了一种恶性循环了。在医院里边治病，就把病人当机器，很少有人去考虑这个人吃不下东西会怎么样啊，实在不行就给你输什么什么的。这些因素如果同时出现在一个孩子身上，就等于说大难临头了。这样的情况死个人也不是什么离奇的事。这个医案就简单地想到什么就跟大家一同交流一下。

服桂枝汤、大汗出、脉洪大者、与桂枝汤、如前法、若形如疟、一日再发者、汗出必解、宜桂枝二麻黄一汤、（25）

桂枝一两十六铢去皮 芍药一两六铢 麻黄十六铢去节 生姜一两十六铢切 杏仁十六铢去皮尖 甘草一两二铢炙 大枣五枚擘

右七味以水五升、先煮麻黄一二沸、去上沫、内诸药、煮取二升、去滓、温服一升、日再服、（注）本云桂枝汤二分·麻黄汤一分·合为二升·分再服·今合为方·（例）将息如上法、

胡希恕：这个头一节啊，“脉洪大”是错的，这个讲到后头就知道了，他这应该是脉浮，洪大呀改个浮就对了，后头有。桂枝汤发汗后外不解，脉浮者还用桂枝汤。这个洪大是错的。这个洪大是个实热之像，白虎汤证下边有啊，恐怕抄写的时候他把下面那个脉写到这里了，这是错的。脉浮，脉浮他病在表嘛。那么已经服过桂枝汤了，服的不合法。我们头前讲桂枝汤啊，就是温覆絜絜汗出，要是似汗出者

更益佳，大汗流离病必不除嘛，这个就是犯这个（弊）病了。那么吃了桂枝汤，大捂大盖啊，人出了一身大汗，这个表是不会解的，如果脉浮者可以吃桂枝汤如前方，还像以前服用桂枝汤的方法。那么这一段，这里头也说明一个定法啊，如果是表证我们发汗后，就是桂枝汤发汗后表不解还用桂枝汤，那么麻黄汤发汗后表不解呢不能用麻黄汤了，也是用桂枝汤，这也是一种定法，所以桂枝汤看起来是一个平稳的药啊，它这个伤津液不重的。那么下之后也是，太阳病不可下之，要是下之后表不解呢，也可以用桂枝汤。那么下也伤津液啊，津液有伤而表不解，那只能用桂枝汤，这桂枝汤我们以前讲了既是一个解表去热，同时呢它也是安中养液，所以那个大汗出之后而表不解脉浮，而仍然可以“服桂枝汤如前法”。“若形如疟，一日再发者”，他如果定时发寒热，就是疟疾了，一阵冷一阵热的，一天啊再发，两次，那么这个是需要桂枝二麻黄一汤。为什么呢？他这个地方啊，说如果吃完桂枝汤之后大汗出之后，他不出汗了，而是变成疟疾似的，一天两次发寒热，这个定时发热这是桂枝汤证，咱们没讲到这个地方，头前也有了，桂枝麻黄各半汤咱们也说了，可是他没有汗，这就是麻黄汤证。但是他这一段啊桂枝汤证多，与上面那个是身必痒，那个汗啊吃药出不来那个样子，而且面有热色，那个麻黄汤证啊就要比这个汤证多一点，所以古人这个用药严的很呐。那么这个形似疟，他也没有汗，可是麻黄汤证呢上面那个对着一看就知道了，他比那个少，没有“身必痒不得小汗出”，那个没有，其它要出汗的情形没有，所以这样子麻黄更少了，所以中医这个辨证呐，要拿着这个书看呐严的很，所以这样才能好病，他用桂枝二麻黄一汤。

桂枝二麻黄一这个方剂啊，也是一个极轻极轻的。你看看后头它那个方子的解释就知道，他说“本云：桂枝汤二份，麻黄汤一份，合为二升，分再用”。他说本来啊，他是这么一个对药物的用法，桂枝汤用二份，麻黄汤用一份，共计喝多少呢，共计喝两升，这个合法呀

他古人是这么个办法。麻黄汤也煎好了，桂枝汤也煎好了，那么随便拿一个东西也行啊，拿一个匙子也行，你舀二匙子桂枝汤，舀一匙子麻黄汤，往另一个器皿舀，共计舀两碗，那么他们俩还是二比一的比例，所以呀原来的本云，就是这个方子仲景以前呐，是这么个办法，就是把这两个药方，桂枝汤取二麻黄汤取一，取到二升，然后分成两份服。那么现在张仲景呢，他就把这个方子啊，药物合成一方了，将息如前法，将息就是面肉五辛那个禁忌呀什么的，但是这个不要喝稀粥了。根据药物的分析啊，他这说桂枝汤取 5/12，桂枝汤份量根据原方的合法啊取 5/12，麻黄汤他取的是这底下也有，取的是 2/9，这 2/9 和 5/12 比啊，也正是 2 比 1。他这个取法药量更轻了，轻的很了，所以这个方子吃下去并不大出汗，稍捂一捂、盖一盖也就是微微的透表而已。

所以桂枝汤，得的桂枝汤证，服用不合法呀，也容易造成大汗出而病不解，如果这个脉还浮，不是洪大啊，洪大要改它，那么还可以与桂枝汤，像以前的那个饮服法，如果病变成这么一个病，就像疟疾似的，定时发寒热，一天发两次，那么这个时候啊应该少发汗，它用桂枝二麻黄一汤，这一节的意思是这个意思。

李冠杰：这个条文在《康平本》里也是顶格排版的条文。

《康平本》和《宋本》这条里边有一字之差，就是“形如疟”和“形似疟”，这个没有什么质的区别，没必要太在意。

直译：病人服桂枝汤后，致使大汗出，如果脉洪大的，可再与桂枝汤，并按正规的要求服用，同时做好护理（这等于说是做一个延伸了，但他就是这个意思，咱们里边详细说），如果出现如疟症状，发热恶寒，一天发作两次的，那么得汗出就能解除，宜用桂枝二麻黄一汤治疗。

下边我们解读一下：

这一条论述的是服了桂枝汤以后，因为护理不当造成大汗出的情

况。在桂枝汤方后注解里边有这么一句话，出现大汗淋漓，病必不除。

“病必不除”会是什么样的情况？这一条说的就是这种情况，喝了桂枝汤，病没有好，那么怎么办呢？下边给了治疗办法。

“服桂枝汤，大汗出”，这里边隐含着另一个问题，整个条文包括后边的治疗方剂给我们佐证了这是一个桂枝汤证。如果不是桂枝汤证不至于让他服桂枝汤，假设是一个表实证恐怕服桂枝汤也难以造成大汗出。这应该是一个正治，但是正治出现了汗出过多的情况，可能性最大的就是护理不当，喝了桂枝汤以后，或者大捂大盖，或者环境太热了，造成汗出太多的情况。

这个“脉洪大”胡希恕说是笔误，应该是抄错了。而且对这个症状，历史上早就有质疑。也有人解释，服了桂枝汤以后，出汗太多，人虚了，虚阳外泄，这是中医最喜欢玩弄的一个辞藻，虚阳外泄，所以出现了“脉洪大”这种情况。

还有另一种解释，服了桂枝汤以后出汗太多，仅现“脉洪大”这么一症，还有这么解释的。实际上这种解释都偏于过于机械。

我觉得是这样，我们没必要完全把这个“脉洪大”说成是一个错，咱们先不去考虑这一点，因为我们没有直接证据，除了推理之外，找其他的佐证之外，作为这个文字本身，我们没有任何证据说它是错的。这些版本大概都是这个样子，都是这么记的。那我们应该怎么去看？首先应该明确认识一点，这个时候的人绝对不仅仅是一个“脉洪大”，如果一个病人得了感冒，我们认为是桂枝汤证，他喝了桂枝汤以后，大捂大盖，又出了很多汗，一摸他的脉又洪又大，但是人很舒服，有必要还让他吃药吗？绝对没有必要了。这里边还有一个很重要的没有说，就是表证没有解除，他还有一系列的表证，这一点很重要。我们读这个条文的时候，把这个“脉洪大”放到后边，我们去解读那些字外的意思，服了桂枝汤以后，人出的汗太多，就是表证并没有解除，仍然存在着一大堆的表证。这时候再去摸摸脉，不是以前的那个脉了，

发生了变化了，“洪大脉”。假设我们在临床上真碰到这个事，桂枝汤证，出汗完了表证没解，你再摸摸脉，真要是洪大脉的话，你看看真没里热，绝对没有里热之像，你也不妨给他吃一次桂枝汤试一下。但是胡老否定它，我觉得应该有临床的一个经验，胡老一生用经方治病，至少可以这么说，胡老讲这个的时候是八二年，是晚年了，他这一生没有碰到过一例这样的病人。

我们参照一下看第 62 条，发汗后脉沉，身疼痛，脉沉迟者，那个脉是个沉迟脉，也是发汗过多了，咱们讲那条时还会详细讨论，但是出现了另一种情况，津液虚得厉害。这个呢就是发汗太多，还没到津液虚到四肢九窍都缺乏营养造成肌肉疼痛这种程度。所以像这种情况，还要用桂枝汤来治疗。

后边的“如前法”，千万不要理解成你上一次喝了桂枝汤大捂大盖后让他出了大汗，是让你按着正规的要求，让他微似有汗。这一条等于是补充了表证的另一个治疗原则：桂枝汤证如果服了桂枝汤出了大汗，表仍未解的，还要用桂枝汤来治疗。咱们这样说，把脉绕开，这个道理就非常清楚了。

这个“脉洪大”也有可能它真的出了错了，不管它出错也好，不出错也好，当我们知道这个原则以后，比如他出现沉迟的脉，但是没有身疼痛，还有表证，还维持以前的表证没有质的变化，没有里热，也没有里寒，也没有半表半里证的发生，你再让他喝桂枝汤就可以了。这条实际上就是要跟我们说这个原则。

历史上对这个东西争议得很多，翻来覆去的，实际上就是过于机械，没有必要那么机械，这是上半段。

下半段呢，“若形似疟，一日再发”，发热恶寒，一阵一阵的，一天发作二次，这个特别像我们前边说的桂枝麻黄各半汤，但是它发作的次数少。我们可以认为：像这一类发作次数少的，麻黄汤证占的比重就要轻了。

“汗出必解”，这是古人总结的一个临床经验，也是对治疗机理的一个解释。

具体的方法是用“桂枝二麻黄一汤”。这个方剂我想咱们也没必要再去讨论，咱们已经学过桂枝麻黄各半汤，这个就是麻黄汤占得分量少，这又是一个轻剂。这条里边是同样的治疗，可能造成二种情况：一个是病情没好，没有明显的减轻；另一个是病情有所减轻了，但是没有完全好。那么药也跟着发生了变化，它发生什么样的变化咱们就跟着它，这等于说又是举个例子。这样的情况有没有可能出现桂枝麻黄各半汤证？也完全有可能，这就给举了个例子。等于给你举例，一个方剂还可以这样的合方，根据证占的分量不同，方剂还可以这样合。

大家以后谁有兴趣，像我这样的做粉剂，你要试试就会有这种体验。比如今天早晨，我就服了1克的半夏泻心汤，0.5克的小柴胡汤，合在一块用水一冲，代茶喝了，到中午吃饭的时候就觉得肚子挺饿，挺想吃饭。

这个方剂临床统计上，它表现出来的症状大部分是发热啊，恶寒哪，像疟疾一样，一天发作二三次，它还有汗出；舌比较淡，苔比较薄；脉浮缓，或者说比较弱这一类的脉象。

大家看看，查遍关于这个方剂的临床统计资料，没有一个是洪大脉的，恐怕像这种病理条件下出现洪大脉的可能性不大。他若出现洪大脉往往会伴有热。

这个方剂治疗的疾病呢，像感冒，流行感冒，荨麻疹，风疹，皮肤干燥综合症，都是一些比较轻的疾病，这是桂枝二麻黄一汤。

服桂枝汤、大汗出后、大烦渴不解、脉洪大者、白虎加人参汤主之、（26）

胡希恕：这一段，就冲着这一节说的。那么服桂枝汤大汗出之后，这个变症多端啊。那么由于丧失津液，最容易，津液丧失，阳明内结，也是常有的事情。二十六呢就说这个，“服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大”，你看这才是脉洪大呢，“白虎加人参汤主之”。它是由于服桂枝汤，这个都不是错用药啊，都不是误治啊，这就说明，这个表证这个期间是桂枝汤证，那么服桂枝汤，服桂枝汤不应该大出汗，就是这个护理人呐没搞好，大捂大盖，他是大汗出。这个大汗出啊，这个病绝对不好的，由于丧失津液太厉害，那么反倒造成胃不和这个里热，所以大烦渴不解。这个“大烦渴不解”，不是表不解了，那么服桂枝汤大汗出后，表没有了，可这个由于津液丧失，它就动了里热了。

“大烦渴不解”，烦躁也厉害，渴得也厉害，这时候脉呢洪大，脉洪大是里热的情形，所以上边那个“服桂枝汤大汗出脉洪大”是错的，那么这也看出来，那个应该是脉浮。这个里热大烦渴，这是白虎加人参汤证。这个白虎汤证啊，不一定渴。脉洪大，身热有汗，口舌干燥，这就可以是白虎汤证。但是津液太伤，他就要渴了。津液伤他渴的时候啊，你必须加人参兼以健胃。这个要是热，津液伤了，咱们后世就不这么治了，后世认为这个呀，都得滋阴。究竟是胃气不复，你这个津液不生，尤其它是在白虎汤这个基础上大量用石膏，更容易影响胃，所以必须加健胃的东西。咱们现在也说呀，这个人参是补气的，补气就生津液，它就是起（生津液的作用）。人参这个主治呀，它治心下痞硬啊，就是治这个胃，胃虚有心下痞硬的这种情况，你吃人参就对头了，后面有的是加人参的这种方剂，那好理解的。一般对这个白虎汤啊，大家都知道这个石膏是个解渴药，其实它是除热药，它不一定渴，主要的这个（治）渴的是人参，这个我们在这个书上就可以看出来，凡是白虎汤没有一个说渴的，你们看一看就知道了，连《金匱要略》带这个《伤寒论》，是加人参都是渴，“欲饮水数升”

啊，“渴欲饮水”啊，像这个“大烦渴”啊，全要加人参，可见这个人参啊，它是有健胃生津的作用，也就后世说的补气呀，古人这个气分，在他的书上就是津液。这是这一段，服桂枝汤，由于大汗出，那么上边说呢，要是脉浮，还在表，可以与桂枝汤，如果“形似疟”，这个也在表，也在表不过它是桂枝（汤）麻黄（汤）共有的证候。那么定时发寒热，这是桂枝汤证，可桂枝汤证呢，它要有汗出的，“时发热汗出者桂枝汤主之”，那后头就有的，这个他不汗出，不汗出呢当然有麻黄汤证，由于桂枝汤证明显，麻黄汤证不明显，所以它这个麻黄汤少搁，桂枝汤多搁。那么桂枝二麻黄一汤这个方剂，我们要用它，怎么用呢？我们遇到一个病，是桂枝汤证比较多，麻黄汤证比较少，也需要解表，让他微汗，可以用这个方子，他只能得小汗啊。可是服桂枝汤大汗出，还能够由于津液丧失太多，动了里热，而为白虎加人参汤证，就是大烦渴，脉洪大，就是我们方才讲的这一节。这个白虎加人参汤这个方剂呢，看后头就行了，知母、石膏、甘草、粳米。。。。。。（音频缺失）。

但是这个药确实还得有，烦躁，这个知母去烦躁，那么知母配合石膏，苦寒，加这个石膏更寒了，那么这个胃受不了，所以他要搁粳米、甘草，这两个药啊，它都是一个甘药啊，咱们说甘药补脾嘛，其实那也不光补脾。它这种甘药啊，尤其这个粳米，咱们这个一般拿这个大米熬粥呢就知道了，它粘得很，它生一种胶粘质，那么西医说它这个是种粘滑药了，甘草也是，这个搁到一起煎，我们吃下去，它能把这个胃使它不吸收，在胃里头，它能够挂一层这个粘滑药，就起这个作用的，它能保护胃，它对这个知母石膏这么个大苦寒的，对胃没什么毛病，所以古人这个药配伍得非常有意思，他搁大量的甘药。那么如果他渴，那么你光用甘草粳米这个药，也不足以济事了，你非搁人参。这个人参它是健胃的，那么它配合甘草、粳米，那么这个胃气才能够复健起来。这两个药去热，这三个药健胃生津嘛，所以这个大

烦渴，这个津液亏到这么一个份子上了，你非得加人参不可。

我们一般用呢，当然是，要是不烦渴，只是口舌干燥，人烦躁，脉洪大，也可以使白虎汤，他不渴也可以使，但是那不必加人参。这个药的煎服法，这个书说的还挺好，那么这五味药，煮米熟，这个米熟了，这个汤也好了。那么这个是这种药它煎的时间都长，它以水一斗啊，你看那旁的，六七味药它都是七升，或者六升，唯独这白虎汤它搁一斗，它就煮长时间。那么米熟了，这个汤也成了，这时候把渣子去了，温服一升，日三服。所以咱们要是对有石膏配伍的这种方剂，那么也要多用点水，时间要它长一点，咱们现在也常常地把这个石膏单煎，也可以的，先下锅。

李冠杰： 这个条文，《宋本》在条文的后边有白虎汤的方剂，《康平本》没有。你看《康平本》里边绝对不会有一个方子同时出现两次的情况，这才更能体现古人的那个行为的风格。

这个条文在《康平本》里也是顶格的条文。

直译一下：病人服桂枝汤，致大汗出后，出现了严重的烦渴，而且不能缓解，脉洪大的，为白虎加人参汤主治之证。

解读一下：

“服桂枝汤，大汗出”，跟上边那个有这么一点区别。有可能是两类情况：一个呢，他本身就是一个桂枝汤证，服了桂枝汤以后，护理不当，造成大汗出，津液损失过重，导致人体发生了里热，这是一类情况；另一类情况呢，这个患者本身表现似乎是桂枝汤证，但是他已经有了里热了。比如说这个病人是个麻杏石甘汤证，虽然有表证，但是同时有里热，桂枝汤是一个温热药，所以说就是误治了。

那么误治了以后，一方面大汗出，体液损失非常严重，另一方面里热也会加重，那么就造成这种情况。这儿呢，我们说的是病因一方面的。经方理论就有这么一个特点，不管有没有上边这些原因，这个条文即使是没有“服桂枝汤，大汗出”的这种情况，如果出现了里热

证，同时伴有津液虚的，像汗出、发热、口渴欲饮，“脉洪大”这一类的话，也得让他喝这个方剂。

这里呢，你认真地读的话，你可以从中体悟到很多东西。告诉我们用桂枝汤，是正治，如果护理不当，有可能出现这种情况；如果误治，完全有可能出现这种里热津虚的情况。

“大烦渴不解”，这个用字非常得精练。有烦，有渴，而且大烦渴，非常严重；这个不解，当然包括了烦不得解，这个渴不解里边隐含喝了水也不能解渴。这儿就涉及到白虎汤证的病理。他喝了水为什么不解渴？就是说对津液的吸收还存在不良的情况。

这个“脉洪大”放在这个地方非常得贴切。那么“脉洪大”是一个什么样的脉呢？《中医辞海》上边就是这么形容：状如洪水，滔滔满指。非常非常形像。这个“洪大脉”有时候，在临床当中会觉得很奇怪。我就碰到过这样的病人，80多岁的一个老人，坐在那地方很安详，也不怎么说话，而且你看他一脸的乐观。他家人就说了，这几天老头身体不太好，有点发烧。摸摸脉吧，一摸脉，那个脉就是这个样子。觉得很奇怪，这么大的年龄，体质又不是说多么壮，而且平时也少活动，会出现这样的脉？那个人呢，因为他口渴的不明显，后来就给他用了白虎汤，吃了两天就好了。

实际上这就反映了一个什么？反映这个人体体内机能过度的亢奋。人体大部分的器官都处在一种亢奋状态，整个的循环系统也会随之呈现一种亢奋状态，血管里边的血流量就会大，包括心脏博动的次数，也会常常伴有数脉，心脏博动的次数也会快。

这个方子一共五味药，就是在白虎汤的基础上，加了3两人参。石膏、知母、甘草、粳米，这四味药就是白虎汤的组成，再加3两人参，就是白虎加人参汤。知母和石膏都是去热解烦的药；甘草在这个地方，起到一个缓急迫的作用；粳米在这儿，起到健胃生津的作用。后世有人就说用山药代替粳米，行不行？我也试过，行。但是，如果

说这个人真正热得很厉害的话，像那种热的人差不多都出现昏迷的这种情况，真正是属于里热那种，事实上还是粳米要好一些。为什么？因为粳米是寒性的。山药呢，反倒是偏温性。但是，都能起到保护胃黏膜的作用。

人参这一味药，作用就非常重要了。能起到一个什么样的作用呢？能改善胃对水分的吸收。白虎加人参汤证有一个特点：渴欲饮水数升。就是他老想喝，喝了以后他还渴。为什么会渴？一方面是人体里热严重过于亢奋；再一个就是胃对水分的吸收功能不好，不能很好地把水分转化成人体有用的那些体液。人参就有改善这种情况的作用。

把人参跟白术比较一下：白术呢，也是胃对水分吸收不好，但是这水分在胃里边停滞的，这个时候喝白术这类的药，可以解决这样的问题。如果人喝水以后，未必在胃这个地方停着，但是人体还是缺少津液。这个时候，胃有效转化水分的效率太低了，这方面的功能不好。人参能解决这方面的问题。所以说，人参是增加津液的；白术呢，是祛水的。它们都能改善胃的功能。

胃里边如果没有停水的话，要是吃白术的话，反倒是不好。如果胃在吸收水分方面没有缺陷，没有虚弱的状态，甚至偏于实，要是吃人参的话也不好。大柴胡汤证是实证，里边就没有人参；小柴胡汤里边有人参，是虚证。

我呢，把白虎加人参汤的方证对应的现代病，仔细地整理了一下，整理得比较全面。在整个学习经方的过程当中，我们对比较典型的方剂，有意义的方剂会跟大家详细地解释。目的就是想让大家知道经方里边最基本的一个规律。就是说，任何一个方剂的适应证都不是一个固定的症状群，不是死的，都是活的。有典型症状，还有一些或然症状，有时候会出现，有时候可能还会没有。这是一种情况。

另外一个呢，我们把这个方剂治疗的现代疾病，分一分类，简单

做一个分析，我们也能从中找到一些规律性的东西，而有所感悟。

白虎加人参汤这个方证，据临床统计资料，比较典型的是：发热，口渴欲饮，汗出，烦躁，这些症状出现的频率是最高的。还有一些或然症状，就是有的医案里边有，有的医案里边没有。

但是，上边这些症状尽管是典型症状，出现频率高，也并不一定在同一个病人身上全都有这些症状。大致上不会脱离这个方向。或然症状，像背微恶寒，小便黄赤，尿频量多，头痛，呕吐，四肢厥逆，或者神昏谵语，失眠，或者食少纳呆，腹满，这些症状都是。

白虎加人参汤证，就是一个人体偏于里热，津液又虚。但是，偏于热津液虚了以后，不同的人程度不同，他会有不同的反应。比如四肢厥逆，这是一个里热的病，而且机能偏于亢奋，他怎么会四肢厥逆呢？人体热到很严重的程度以后，破坏了循环系统正常的工作环境了，简单地说就心脏受不了，它的功能啊，从以前的亢奋一下进入一种抑制状态，血液循环反倒是不好，血不达四末，能量供应不到，就会出现四肢厥逆。像这种情况，出现在个别人身上。但是有这个，你也不能不知道。了解它的机理后，你再碰到这样的病人，你也不至于辨证发生错误，发生疑问。看着明明是一个热证呀，怎么会出现四肢厥逆呀？其他的，就比较好理解了。小便黄赤，本身就是里热呀；背恶寒，往往是因为胃功能不好，所以影响到背。

脉象：洪大有力的脉是最多的，有的会表现洪数脉，有的记录的就是数脉。

舌像：频率最高的就是舌红、苔黄或者说燥。

白虎加人参汤里边有一个很特殊的症状，原文里边有“时时恶风”。在 168 条里边，“伤寒，若吐若下，七八日不解，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，白虎加人参汤主之”。但是，这个“时时恶风”，在临床统计资料里边，几乎没有一个医案是有这样症状的。第 168 条一开始是伤寒，是表证，或者说是吐了，

或者说是下了，误治闹了七八天，表证还没解，实际上，“时时恶风”是指的表证还没解，一再地误治，伤到里了。伤到里以后，很多情况下是造成里虚。但是，还能造成里热，津液虚的这种情况。这一条说的是这么一种情况。应该是表证还没有全好的那么一种情况。

现代应用：糖尿病、流感、败血症、湿疹、流行性肝炎、急性白血病、再生障碍性贫血、高血压、斑疹伤寒、日光病、鼻炎、钩端螺旋体病、中暑、热射病、脑出血、甲状腺机能亢进、皮肤瘙痒、皮肤充血、肾炎、胆囊炎、夜尿症、急性食道炎、急性胃炎、急性痢疾、大叶性肺炎、乙型脑炎、流行性脑炎。

从这儿我们能体悟到什么？比如大叶性肺炎，你会有这么一个概念，白虎加人参汤可以治大叶性肺炎。要真是有了这样的概念，那你在了解经方的过程当中又走了弯路了。大青龙汤还能治大叶性肺炎呢，还有很多其他的方剂也能治大叶性肺炎。我们应该怎么去看呢？我们最起码应该想到什么？经方和具体的现代病名之间，甚至包括我们中医里边命名的一些病，没有固定的对应关系，这一点很重要。但是，没有这个关系的话，我们在学习过程当中为什么每一个方剂还尽可能地给大家罗列这些东西呢？你在这些东西里边可以有所感悟。

这个方剂治疗的这些病里边，有胆囊炎的记录。实际上真正用来治疗胆囊炎的机会就很少。糖尿病用到这个方剂的机会就比较多。因为糖尿病三多里边，就跟白虎加人参汤证差不多啊。但是呢，你又不不能说白虎加人参汤是用来治糖尿病的，又不行。这里边你慢慢去体验吧，体验体验，最终你就体验出它的规律在哪了。

这个病啊，你就当做一个证来参考。我们刚才不是说那个证了吗，我们把所有临床统计的证放到一块，会发现并不是所有的证都会在同一个人身上表现出来。这个病人会表现这几个，那个病人会表现那几个。你只要是对经方掌握得比较熟，有一定的基础了，你就能准确的辨成他是哪一类疾病，而且能确定具体的方剂。尽管那个证不是一个

固定的，却能用来确定治疗方剂。现代疾病病名呢，我们只能看做这是证的一种参考形式，有一个参考因素，我们多了一个辨证因素。

比如糖尿病，糖尿病你可能首先会想到白虎加人参汤。你再去找白虎加人参汤的证啊，他要没有证，你给了他肯定疗效不好。如果他有肾气丸证的话，你应该用肾气丸嘛。

我们反复地品来品去，最终你就品出规律所在了。

那么，顺着这个现代疾病呢，我们再仔细地细看一下，白虎加人参汤涉及到内分泌系统的糖尿病，甲亢；呼吸系统的大叶性肺炎；泌尿系统的肾炎；消化系统的胆囊疾病，胃肠疾病；神经系统的脑炎；循环系统的败血症，高血压，再障；体表上的一些病，感冒，皮肤病。涉及到了方方面面。

从中能够得到什么启示呢？我们今天看到的白虎加人参汤证的这些现代疾病里边，就给我们佐证了这种道理：人体过度地亢奋，致使某些器官首先不能适应这种亢奋的机体了，不能适应这种环境，然后就开始出现问题。比方说糖尿病吧，胰腺长期的在过于亢奋过于热的体内，正常功能就会失常，出现胰岛素分泌下降。下降了以后，人就会出现尿糖指标高，就这么一连串的出来了。人体的亢奋就是真正的原因。

从这我们就能体悟出，经方认为这个人病了。具体到白虎加人参汤证，就是里出现了热证，是一个阳性证，同时又有津液虚，也就是水证的虚证。

人体就是在这样的病理状态下，可能出现这么一大堆的疾病。具体到一个人身上，哪一个器官，哪一个环节最薄弱，就先从哪地方得病，哪个地方就出现病变。这不就是经方对病理的阐释么？而且这种阐释，也是与时俱进的，这也都要用到现代这些东西。

大阳病、发热恶寒、热多寒少、脉微弱者、此无阳也。不可大发汗、宜桂枝二越婢一汤、^{（27）}服桂枝汤、或下之、仍头项强痛、翕翕发热、无汗心下满微痛、小便不利者、桂枝去桂加茯苓白术汤主之、^{（28）}

桂枝二越婢一汤、

桂枝_{去皮} 芍药 麻黄 甘草_炙各十八铢 大枣四枚擘 生姜一两二铢切 石膏二十四铢_{绵裹}

右七味、以水五升、煮麻黄一二沸、去上沫、内诸药、煮取二升、去滓、温服一升、^{（注）}本云·当裁为越婢汤桂枝汤·合之饮一升·今合为一方·桂枝汤二分·越婢汤一分·

桂枝去桂加茯苓白术汤、

芍药三两 甘草二两_炙 生姜切 白术 茯苓各三两 大枣十二枚擘

右六味、以水八升、煮取三升、去滓、温服一升、小便利则愈、^{（注）}本云桂枝汤·今去桂枝加茯苓白术·

胡希恕：这一节，一般的讲的也都是错的多。

这个太阳病啊，发热恶寒说明还在表了，但是热多寒少，这个热多寒少啊，它是冲着这个发热恶寒说的，不是这个病特别的有壮热，不是那个样子，它把这个发热恶寒，那么在这个发热恶寒的这个情况，热比较多而寒比较少，不是在这个发热恶寒之后另有大热而恶寒少，不是那个意思。那么这个寒少啊，我们讲太阳病，太阳病的恶寒是一个主要的证候啊。这个寒少说明这个表啊，要罢，就要解了。那么这

个病呢虽然发热恶寒，但是由于热多寒少，那么这个病啊表欲解，热不退，恐怕要转成阳明里热的病，它是这么个意思。可是转成阳明里热呢，你看前面白虎汤（26 条白虎加人参汤），脉洪大，这个脉微弱。微弱在这也是有两个意思，一方面冲上面说的，虽然发热恶寒，但是它寒少，表证欲去了，虽然这个热较比多，但是脉微弱，这个外邪已去啊，所以没有多大里热，这个脉微弱还有一个意思，底下他注了，“此无阳也”，这个“无阳”就是津液，就指津液说的。他这个书上啊，尤其在表证的时候，他常说的无阳都是指这津液，脉微者为亡阳嘛。脉弱，咱们头前讲了，阳浮而阴弱，那个弱就是血少了。总而言之就是气血俱虚呀，就是津液血液都少啊，所以他说“此无阳也”。“此无阳也”，不指这热说的，上面明明说的发热恶寒，热多寒少，还此无阳也，还没有热，这不是瞎扯吗。这一句真就有这么注的，这么注就是错的。这个此无阳也，没有津液，就是亡失津液。“不可发汗”，这个发汗啊，最耗伤津液了，那么唯独这个津液虚，所以不可发汗，宜桂枝二越婢一汤。

那么这个表不解怎么办呢？还发热恶寒嘛，那么就稍稍地用桂枝二越婢一汤清肃其表里。这也是个发汗药啊，发汗药呢但是它不大发汗。这个越婢汤啊，在这个《伤寒论》里没有，在《金匮要略》里头有。它就是麻黄、甘草、大枣、生姜、石膏，这几个药就叫越婢汤，那么桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣就是桂枝汤了，它是桂枝二越婢一。

这个越婢汤治什么呢？在《金匮》里头啊《水气篇》里头有，它治风水。所谓风水啊就是全身肿了，脉浮，出汗，身上没大热，同那个麻杏石甘汤差不多。麻杏石甘汤不也是嘛，喘而汗出，身无大热。它这个热半陷于里了，它这个汗出与桂枝汤的汗出是不一样的，它这个由里往外，就是蒸而汗出，但是不到阳明病蒸蒸发热汗出，不到那个，所以无大热呢。无大热啊就是冲着阳明里实说的，真正里实那蒸

蒸发热啊，那身上热得很。它这个无大热，不到那个程度，但是里头也有热，所以搁石膏，但是表也有，他搁麻黄。越婢汤这个麻黄用的量大呀，他用六钱。我们要治这个表有水气，你要是发水气，麻黄非重用不可。那么在这个方子里麻黄用量相当轻啊，他把这个越婢汤用八分之一。源起这个麻黄用六两，我们现在用就是六钱，18克，要拿8除呢，不到一钱了，那很轻很轻的了。这个桂枝汤啊，用的是四分之一。四分之一、八分之一，也是二倍吗，所以用桂枝汤用的比较多，但是也特别少。他把这两个方子合起来用了，合起来用呢，就失去越婢汤的作用了。

我方才讲了，想要发水气，麻黄必须重用，那么连一钱也不到，它就不能去水气了。那么桂枝配伍麻黄啊，我们在临床上这个药物配伍的规律要知道，桂枝配合麻黄出大汗，而石膏配合麻黄呢反倒治汗出。你看这个方子呢，既有桂枝汤加麻黄，可以出点汗，但是又配伍石膏，出汗也不大，所以这个方子它清肃表里啊，它能够去里热，因为有石膏的关系，也能稍稍解外，有微量的麻黄，那么大部分呢还是桂枝汤证。我们结合这一段就可以看出，桂枝汤证比较多。由于桂枝汤证主要是津液虚，脉微弱，要有表不解，还现桂枝汤证，但又不完全是桂枝汤证，他没有汗出。你看这一段里头啊，他说“太阳病，发热恶寒，热多寒少”，并没有汗出。可是没有汗出，又不能大发汗，因为脉微弱，桂枝汤证明显，但是麻黄汤证不明显，所以这个麻黄量特别小，而且他不搁桂枝二麻黄一汤，那个麻黄汤里没有石膏啊，因为还有热，所以稍用点石膏，这个石膏量也不重。我们再看看这个分量，搁到一起呀，每一个药只十八铢，古人这个度量衡啊二十四铢是一两。那么古人的一两呢，我们现在开方子就是一钱，古人都是一煎煎三付药嘛。这个十八铢不到一两啊，一两的四分之三。所以这个药啊，药量非常的轻。那么吃了这个药啊，要是表里都有点热，可以用，但是在这个发汗药之中是最轻最轻不过的药了，所以他搁个“不可发

汗”，这个专指的是麻黄汤了。你说太阳病发热恶寒，真正的表证无汗，我们一般常打算用麻黄汤。所以这个病啊，“脉微弱，此无阳也”，是万不能发汗，不能用麻黄汤。我记得有一个人问过我这一段，说“此无阳不可发汗”，桂枝二越婢一汤是不是发汗药？我说这个不一样，它有所指，这个书说不可发汗，都是指的麻黄汤。那么这个地方用麻黄汤就了不得了，那非坏不可。所以说“脉微弱者”，就是亡失津液，这个不能用麻黄汤来大发汗，根据这种病情啊只能够稍稍地清肃其表里而已，所以用桂枝二越婢一汤。我们讲到这，咱们讲的这几个方剂都是小发汗法。咱们头前讲的桂枝麻黄各半汤，桂枝二麻黄一汤，和这个桂枝二越婢一汤，这几个方剂也各有不同。桂枝麻黄各半汤就是桂枝汤与麻黄汤，这两个证候相合，大致差不了什么，但是不可大发汗，全是小发汗法，药量都特别轻。桂枝二麻黄一汤呢，是桂枝汤证多，而麻黄汤证少，也是小发汗法，这个方子尤其小发汗。不但有表证，里头也有热，所以热多寒少，在这个地方你就看出来了，他这个表证要罢了，热多寒少，有入里之势，但是这个病非常地轻，脉微弱也就是邪轻的一个问题了，同时啊这个人津液也虚。这个不但麻黄汤用不得，用一般的桂枝汤也是不行的。所以他一方面用桂枝麻黄稍解其表，另一方面用石膏清其里热，它是这么一个方剂。

这个桂枝去桂呀，这个桂也可疑，在《医宗金鉴》他改芍药了，我认为这是对的。因为他这个表还不解嘛，你把桂枝去了，拿什么解表？所以应该桂枝去芍药，我们经常用也是桂枝去芍药。我认为《医宗金鉴》还是对的，这个书错字有的是，像头前那个脉洪大，那肯定是错的。这段书主要注重这个“仍”字，他说这个病呀，根本就不是桂枝汤证。他根本就是“头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满，微痛，小便不利”，根本就有这个病，就是这个证候。这个大夫看到这个“头项强痛，翕翕发热”，唉！这个像表证，就给吃了桂枝汤了。这个就是药不对证了，所以这个病不会解的。他又看到“心下满，微痛”，

心下指着胃说的，又满胀又疼，像里实，他又给吃泻药了，也不对头，所以他这个服桂枝汤，或又吃了泻药了，他这个症状一点没变，仍“头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满，微痛，小便不利者”，他才用这个方剂。

这个我们在临床上常遭遇，他如果里有停水，就是小便不利呀，影响表不解，那么里头胀满呢，你泻下也不行，非利小便不可。这一段就说明这个问题，他由于小便不利，水不下行，他这个里边呀，他这个是古人的临床经验看出来，里气闭塞，他表不会通透的，所以非利小便不可。你无论是发汗，越发汗越坏，发汗激动里边的水，那变证多端呀。那么下也不行，所以这里发汗呀或者下之呀，他这个病是永远不变的。那么怎么办呢？有表证是有表证，你要兼利小便。他“头项强痛，翕翕发热”，他肯定这是表证。所以他用这个桂枝汤去芍药。芍药这个药呀，我们头前讲这个桂枝去芍药，他脉促胸满，他气上冲的厉害，这个芍药不对头的，他要去芍药。那么这个小便不利呀，常由气上冲造成的。这个气往上冲，它诱导这个小便不往下行，所以利尿药里常搁桂枝。你要把桂枝去了，这个五苓散都有桂枝，什么苓桂术甘汤呀。

那么去芍药是对的，因为他这个还有表证，所以还用桂枝汤。本来是个中风证，所以不汗出，就是因为要通小便，是小便不利的关系。如果这个人小便要是利，肯定他上边这个不会“心下满，微痛”，他就是桂枝汤证。由于小便不利，影响汗不出，那么他气上冲的厉害，所以“心下满，微痛”，他这个水往上不往下，那么表证仍然存在“头项强痛，翕翕发热”，主要原因就是小便不利。所以他用桂枝汤把芍药去了加白术茯苓以利小便。小便一利，这个桂枝汤就发生作用了，表就解了，他是这么一个情形。

我们在临床上要注意这一点，比如说一个感冒，那随便吃点发汗药就可以了，但是他要是明显的小便不利，身上发烧等等的，你要不

利小便，他这个表绝对不会解的。那么他该用哪一个解表药还要用，但是非加利尿药不可，治这个小便不利才行的，这个很重要很重要的。这个书里头后头有的是，就由于里有停饮，不兼去饮，这个表是解不了。下更不行了，后头很多，我们随时解释这个例子。那么这个方子呢，就是桂枝汤去芍药加白术茯苓，白术茯苓这两个药都是利小便，利小便，这个利尿药呀也不都是一样。你像这个白术呀、苍术也是一样的，这个药是温性药，偏于治胃停水，所以“心下满，微痛”。这个茯苓呀性最平，那么这个也是胃有停水，但是它利小便很有力量。胃要是没有停水，这个术要少用，它这个温性，咱们后世也说这个白术也健脾吗。它这个健脾啊，胃里头如果有停水时他有好处。要是胃没有停水呀，是有坏处，没有好处。他这个性温，他这个刺激这个胃呀很容易充血，起码要达到发炎呀冲血呀这种情况。所以咱们看见这个胃虚呀，就用点术吧（这是不完全正确的），可是（要注意）胃要是没有停水，这个术是不要用的，他主要是要利小便。这个临床应用上有，我们随时解释。茯苓这个药呀，在水气里个一种神经官能证用的机会多，像心跳呀，或者是烦躁呀，所以也治失眠。失眠咱们像是这个酸枣仁汤，搁茯神，茯神茯苓这个作用是一样的。

总而言之，茯苓在利尿的过程中，它治神经官能证的机会多。这个白术呀也是利尿的药，但是它健胃的作用多，健胃的作用限制于胃有停水。所以我们平时用药呀也不要把它搞错了，这个人小便不利，他胃不但没有停水，上边还有热，这个白术这个药是不能用的，你看猪苓汤就没有的。

李冠杰：这两条问题很多。通过学习会进一步地感悟到为什么要时时提到《康平本》，因为《康平本》的意义非同小可。这两条在《宋本》里边拆成了两条，在《康平本》都是顶格排版的内容，是同一条的内容。其中具体的字上还有不小的差别，《康平本》中的“不可大发汗”，在《宋本》为“不可发汗”，这一字之差不知道误导了多少

人。

首先，第 28 条和第 27 条是同一条内容的话，那么它和第 27 条之间有一个衔接的关系。也就是说“服桂枝汤”是有前提条件的。什么前提条件？就是在桂枝二越婢一汤证或者在太阳病的基础上，服桂枝汤或者下之，才出现下边这些情况。如果把它分成两条的话，这种衔接关系就不存在了，很容易造成从另一个角度去认识这一条。另外，《宋本》和《康平本》的这个“此无阳也”，再加上把“不可大发汗”改成了“不可发汗”，可以说误导了所有的读者。胡希恕读伤寒论可以说很难有人能比过他，但是胡希恕在这地方都被误导了。这不能怪胡希恕，如果见不到《康平本》，谁能认为这四个字是别人加的旁注内容呀。有一个伤寒家柯韵伯在解释中就提到了这么一个问题，他说桂枝二越婢一汤治不了像这种脉微弱无阳的病理状态，不是这个方剂所治的。但是也就仅仅解释到这儿为止。因为他也没见过《康平本》。所以说《康平本》对我们来说是一个非常好的事。

下边做个直译：患太阳病，表现为发热恶寒，热多寒少，脉微弱的，不能再大量发汗，适宜用桂枝二越婢一汤治疗。如果服桂枝汤或泻下后，仍表现为头项强痛，翕翕发热同时又伴有无汗，心下满微痛，小便不利的，为桂枝去桂加茯苓白术汤主治之证。

下边解读一下，咱们把它也分成两部分内容来解读：

这里的“太阳病”，具体到条文里就是说有许多太阳病的外观，但是同时它还有别的问题，所以这不是一个纯粹的太阳病，是有太阳病的外观，还有别的病掺杂在里边。

“发热恶寒，热多寒少”不解释了。前边有两个方剂涉及到这类的证，它们病理基本是一样的。

“脉微弱”，在这个地方我们还跟桂枝汤里那个脉洪大一样的认识，不要把它僵化。从字面上可以有两种解释：一种解释是稍微见到缓弱的那种脉象，基本上就是一个浮缓的脉；另一种解释就是脉既微

小又弱，是这么一种脉。既微小又弱的脉，放到这个方证里边，临床统计结果里边基本也没有这样的脉。那么是不是作者在强调什么？或者说真的有笔误也不好说。我们还是用相同的办法，我们绕过这个脉象的问题。

这个“此无阳也”是针对“微弱脉”说的，历史上的解释大部分说是阳气不足，胡希恕的解释是津液虚。那么它是不是这种情况呢？这四个字几乎误导了所有的读伤寒的人，这肯定不是张仲景写的了，这个旁注的作者对经方的理论没有真正的悟透。他不仅仅在这个地方做了这样的注，而且在太阴病桂枝加芍药汤里，他见到了“时腹自痛”，加了“此属太阴也”的注，那也是错的，跟这个几乎是一脉相承，都是以旁注的形式出来的，恐怕这都是王叔和搞的。

咱们看一看桂枝二越婢一汤这个方剂，我们能看出什么来？这个方剂是桂枝汤取四分之一，越婢汤取八分之一，把两个方剂合到一块。这里边桂枝汤占了二份，桂枝汤在里边的作用可以简单的这么认为：它和桂枝二麻黄一汤中桂枝的作用没有什么区别，连量上都一样，还是它所治疗的那一部分病，也就是说是用来解表的。越婢汤它是治什么呢？越婢汤对的是什么呢？所有的注家都这么注：越婢汤对的是外有表证里有热。这个方剂就是清肃表里，都在这么解释，但是大家都忽视了一个问题，越婢汤在《金匮要略》里治风水的，风水是体表停饮。如果我们从这一点上，大家再去想一想大青龙汤，它跟桂枝二越婢一汤只有一味药之差，就是把杏仁去掉换成了芍药。大青龙汤除了治表实里热之外，它还有一个很重要的方证就是可以治体表停饮，“身重，乍有轻时”嘛！从这一点上看，这个方剂有一个很重要的问题，恐怕“脉微细”指的就是这一方面的。具体是不是脉微细就没必要去深究了，因为所有的版本都是这个，我们无法再去做进一步地考证。但是从方剂里我们能体悟到，这一条实际上说的是既有轻微的表证，同时又出现了体表停饮。我有了这种想法后，就去临床统计资料中找佐证，

我查到一个书上的临床统计资料，说桂枝二越婢一汤治风湿性关节炎、关节疼痛。大家看这就能吻合起来了，这个证里边还有两个非常重要的症状没有提到，一个是“汗出”，应该有汗出。为什么这么说呢？因为桂枝汤证有汗出，越婢汤证也有汗出，这两个方剂放在一块儿假如反倒是没有汗出了，那就不可思议了。另一个症状应该是“浮肿”，它也可以治，因为它可以去表水的。

就因为对这个方剂理解都有偏差，所以临床统计资料中这样的医案也不是很多，但临床的东西是最客观的，你从里边可以品悟出很多的启示来。可惜现在中医界很少有人搜集、积累、统计这些了，不去做深入的分析，或者说有时候分析的太机械，都没有用的。甚至包括什么季节得病，男女，年龄段啊，这些东西不能说完全没有用，如果每个方剂都弄这个就有点过度繁琐了，事实上没有太大的用处。

第二段“服桂枝汤而下之”。这一条跟上一条是同一条内容，它说的服桂枝汤是在上面条文的基础上服了桂枝汤，或者说是下之。它这儿还有一个非常重要的“仍”字，“仍头项强痛，翕翕发热”，“仍”字是说以前就有这些表证的症状，但是服了桂枝汤以后仍然没有解，这一点很重要。这个地方为我们理解方剂提供了一个非常重要的证据。就是说这个人服桂枝汤之前和服桂枝汤之后，都表现为明显的表证，服了桂枝汤表证并没有解除，也没有出现其他的问题，比如也没有出现象出大汗什么的情况。这个时候还有一些和表证不太一样的地方，这就有一个“无汗”，“无汗”看起来好像不就是个表实证吗？在这个地方大家不要理解成表实证，这个“无汗”跟后边是一个内容，在有表证的同时又表现出“心下满微痛”，这就跟表证无关了，它后边还有一个证就是“小便不利”。有“小便不利”，这个“无汗”的性质就变了，它就不再是表实证了。它是什么问题呢？有“小便不利”，又有“心下满微痛”。“心下满微痛”，比如像厚朴三物汤、小承气汤、甚至四逆散也会出现心下满微痛的情况。这个地方它后边有“小

便不利”，就给这些证一下定了性了。

“小便不利”，我们再去看看方剂，桂枝汤把桂枝去掉了，加了茯苓、白术。这个地方很重要，在历代就有争议桂枝汤是不是去桂？如果去桂拿什么东西来解表？这个事首先从字面上说，桂枝去桂应该不存在抄写方面的手误。为什么呀？其一是各个版本之间都一样；再一个，它这里上边有方名，下边有方剂，方剂后头还有方注，它这是一连串的，不可能把毫无用处的全都改掉。假设是桂枝汤去芍药的话，那得把方名改了，然后方剂里边的药物也改了，所以抄的时候出现手误的这种可能性就没有了。再从病理上来看，咱们简洁一下，不要说得很多了。我跟大家说另外一个方剂五苓散，在有停饮的情况下出现某些表证也有服五苓散的机会，但是你得口渴欲饮呀，然后喝了以后管用，而且还不能有里热，是由于停饮造成的，得有五苓散证。五苓散里边除了四味祛水的药，就是一味桂枝，桂枝的量非常少。那是桂枝在解表吗？当然桂枝肯定有解表的功能，但它的量又少，而且就这么一味解表的药，这个方剂主要是祛水，桂枝还有降气冲，帮助利尿的作用。如果因为停饮表现为五苓散证，又有某些表证的话，它顺便桂枝的作用也能发挥出来。但实际上事实是人体内的停饮是主要的矛盾，把停饮的问题解决了，表证会自然好。为什么？这个人体表现出里有停饮的时候，它还有能力在表的这一层与致病因素作斗争，如果把停饮问题一下解决了，它里边调理病理状态的能量就多余出来了，这些能量一下来到体表，本来它就有能力在体表抗病，再加上能力一足，这个病就好了。

这个时候实际上停饮是一个主要矛盾，而且前边已经喝了桂枝汤表证治不了。因为停饮是主要问题，有停饮的时候单独解表不管用了。喝了桂枝汤，或许也下了，这时候人已经出现了体液有点虚的情况了，体液有点丧失，里头又有停饮，这个时候就不要再发汗了。桂枝汤把桂枝给去掉还有生姜，生姜也有解表的作用。这个时候最主要的还是

有里饮的问题，里饮这么重，小便都不利了，因为停饮胃这个地方都又满又疼，以至于汗都不出了。汗不出是为什么？里边停饮外边的水分相对就少，就没有能力出汗，而不是因为表实证的问题。所以现在的首要任务就是要解除停饮的问题，里边还有生姜，生姜既能解表，又能恢复胃功能。实际上这个方剂如果这么理解的话，桂枝去桂就顺理成章了。

这个方子简单地看一看：桂枝二越婢一汤咱们前边已经说得很详细了，就不去说了。桂枝去桂加茯苓白术汤，为什么去桂已经说了，茯苓、白术都能改善胃中停饮的情况，当然它们还有另外的作用，比如白术还能治一些因为体表停饮造成的痹症，每一味药都不是一个单独的功能，但在这个方剂里，这两味药主要是用来改善胃中停饮的功能。

从方证上看：桂枝二越婢一汤大家看一看统计资料里边出现频率最高的就是汗出，但古人没说，其实不等于没说，这两个方子都是应该有汗出的。关节疼痛、恶寒、头疼、口渴、发热，它又伴有里热了。

舌质：大部分舌质淡。

脉象：有的是表现为数脉，有的表现为紧脉，有的表现为浮脉、滑脉、缓脉，脉象比较复杂一些。咱们解读用一种灵活的方式，既然脉象不好确定，你看一看临床统计的资料，心里边就会很明白了，我们为什么要死在那个微弱脉上？实际临床当中这种情况有很多，不要把脉象僵化就是了，要全面地综合去看待这个方剂。

桂枝去桂加茯苓白术汤的方证：像心下胀满、头项强痛、心下疼痛（心下都是胃这个部位了）、小便不利、恶寒发热，这一类的症状就比较多。

舌质的统计资料没有，本身医案就不多，因为对这个方剂的理解不到位，真正用桂枝汤去桂汤的人就比较少，所以统计上来的数据也不是很多。有一个舌苔是白苔，有白滑腻厚苔，还有偏干的舌苔。出

现这个情况可能是停饮比较重，新水没法吸收了。没有脉象的统计，

从现代应用上看：桂枝二越婢一汤主要治疗一些像感冒、流感、水肿、关节痛（关节炎）、慢性风湿性关节炎、慢性肾炎。尽管病不多，从这些病上我们能看出来，这个方剂一方面解表，一方面去里热，一方面祛表水，如果这么去理解，跟它所治疗的疾病也是相吻合的，跟它临床统计的那些证也是相吻合的。所以说，我们应该去这么理解这个方剂。

桂枝去桂加茯苓白术汤它所治疗的疾病比较单纯了：像胃肠型感冒、流感、癫痫（有一个癫痫统计在里边）。

伤寒脉浮、自汗出、小便数、心烦、微恶寒、脚挛急、反与桂枝汤、（注）欲攻其表此误也·（经）得之便厥、咽中干、躁、吐逆者、作甘草干姜汤与之、以复其阳·若厥愈、足温者、更作芍药甘草汤与之、若胃气不和、谵语者、小与调胃承气汤、若重发汗、复加烧针、得之者、回逆汤主之、（29）

甘草干姜汤方

甘草四两炙 干姜二两

右二味、以水三升、煮取一升五合、去滓、分温再服、

胡希恕：这段是个大段。

“伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝汤，欲攻其表，此误也”。这是头一段，你看他开始就搁个伤寒，伤寒他应该脉浮紧，无汗，反自汗出，这说明他是亡津液了，小便又数，既自汗出小便又数，他这个书说小便数就是小便吃紧呀，就是频

数。这个可以与上边参着看，小便不利影响自汗出，本来是桂枝汤证，他变成无汗了。那么这个小便数，它影响自汗出，虽然是伤寒，他小便数，他也汗出，他有这么一个意思在内，这个书上没有明说。这个小便数说明什么问题呢？大概是胃虚。咱们后世这个医书里有呀，所谓上虚不能治下，这是用五行的方法解释了，胃属土嘛，土虚不能治水。其实这个有道理，这个胃气虚衰，人身上哪里都虚衰。就是虚脱那个样子，脱水那个样子，小便失去收摄，那主要是因为上边胃虚。他这个伤寒本来是应该无汗，由于津液大量亡失，既自汗出又小便数，所致津液竭于内，后边讲阳明病就知道了。“自汗出”，汗出多为太过。伤寒没有汗，发汗，发汗使汗出多，也为太过。太过者，阳竭于里，阳也指的津液了，那大便要干，咱们说的脾约证就是这类的。他这种脾约他不要紧，他是虚证，就是虽然十日无大便，无所苦也。所以这个脾约证你不能吃承气汤了，只能吃些麻仁滋脾什么的。他这个病呀就类似这个情况，他的津液不守，一方面汗自出，一方面小便频数。“心烦”呀，有点胃不和的情景了。“微恶寒”，你看他搁个“微恶寒”，这个“微恶寒”呀，他说明这个，他虽然冠个伤寒，这个表要解，我们刚才讲了，这个恶寒是太阳病的一个主要证候，所以“脉浮，头项强痛而恶寒”，“而恶寒”要加重这个恶寒。如果这个表证，这个恶寒很轻很轻的了，这个表要罢。但是这个心烦，这个里热要生。什么道理呢？就是因为津液丧失。或者此无阳也，不可发汗，这个更不可发汗，所以他说，“反与桂枝汤，欲攻其表”。这时候你再攻表，再让它丧失津液，“此误也”，这是治疗的错误啊。这是头一段。

还有一个问题我们要重视，这个小便数啊，凡是应该发汗的病，小便数绝不可以发汗。这个在《金匱要略》里的《水气篇》他讲过。像我们方才讲越婢汤中的那个风水，是水气在表，都可汗出。惟独小便数者，他有这么一段，他说：“渴而下利，小便数者，皆不可发汗”，这个要注意。这个小便数呀，大概都是里气虚而津液不守，你再发汗

再亡失津液，这个发汗最亡失津液了，这是逆治。那么，他这段也就是说明这一点。自汗出虽然像桂枝汤证，脉又浮，但是小便数，这个津液亡失以至脚挛急，而且表证轻微之极了，微恶寒而已呀，这个病在这个时候啊，这个书上后面有，就应该这个时候吃芍药甘草汤，先治脚挛急观察观察，你看看这里头一点热都没提，他也不发热不什么的，你吃哪路桂枝汤啊，所以根本就是错误。“得之便厥，咽中干，烦躁吐逆者，作甘草干姜汤与之，以复其阳”，这是第二段。

这个药用对了病人好的挺慢，用错了立竿见影，马上就给你个样看看。不应该吃桂枝汤给吃了桂枝汤，吃了桂枝汤马上四肢逆冷，这是什么道理呀？津液再亡失，同时这个胃也虚，这个津液达不到四末，这个手脚离心脏都远呐，所以血液、津液达不到这个地方了，他就凉，这个在内经上有了，它说：“脾为胃行津液”，到脚上脚上能行，到手上手上能握。那么这个因为发汗津液亡失的太厉害了，远处的地方啊，达不到，所以他厥冷。那么在上边也失去润泽，所以嗓子也干，烦躁，吐逆，胃也不和。烦躁，比心烦还加重了，原病只是心烦而已啊，这是又烦又躁，他不能安静，这都是胃不和的一种表现。而吐逆，这都是胃的关系了，这吐逆呀，这个病根本一开始胃就虚。胃虚不能治水嘛，所以小便数。那么，这种错误的治疗，更丧失津液，胃既有热，虚呀他胃里头还有些停水，所以为发汗药所刺激，他反倒吐逆，而且这个病还相当急迫，手脚逆冷，“得之便厥”嘛。把这桂枝汤一吃了，马上这种情况，所以他说“甘草干姜汤与之”。这个甘草干姜汤以甘草为主了，甘草这味药头前咱们讲过了，它也能够养液，也能缓急迫。那么，这个病相当急迫了。这个干姜呢，干姜甘草搁到一起，就是健胃，治呕，它这不是吐逆嘛。我们这个理中汤什么的都是由这个甘草干姜汤上来的。甘草、干姜再加人参、白术就是理中汤啊。

四逆汤也是啊甘草、干姜加附子就是四逆汤。那么吃甘草干姜汤干什么呢？以复其阳，这个以复其阳啊是复津液，这个不是让他再发

热，他根本就热了，他这个时候胃太虚又有热，你主要得恢复胃气，他这个甘草、干姜啊他是温中、健胃、缓紧迫的这么一种药，但是干姜用的量非常轻，这跟我们头前白虎加人参中讲的人参健胃生津液是一个道理。这个时候胃要是不恢复，这个津液是不会恢复的，所以他用甘草干姜来治疗。这个病我想要用滋阴救逆的办法一吃一个死，一看这个人，咽比较干，就是津液太虚了，用点滋阴药，这个不行，他这个胃根本是不好的，也只能够恢复胃气才能够生津嘛，同时用大量的甘草也是大有道理的。“以复其阳”不是复其热，这个“阳”和我们头前说的津液是一致的。胃气恢复，津液充畅，这个四肢自然就温了。“若厥愈、足温者，更作芍药甘草汤与之，其脚即伸”。他若吃了甘草干姜汤，当然呕逆、烦躁都止了。那么“厥愈、足温”，四肢也不厥了，他津液一达到四肢他自然就不厥了，也不凉了。这个时候啊，脚挛急没好啊，“更作芍药甘草汤与之”，这个芍药啊它是个治挛急的，肚子急痛，小建中汤就是加芍药了，在桂枝汤里都是大量的用芍药再加上饴糖啊。这个芍药就治挛急，拘急痛，咱们说少腹急痛，那也是芍药证。那么其他的部位发拘挛呢？芍药也治。那么再给他芍药甘草汤，缓他这个挛急，其脚即伸。我说开始就应该吃这个药，开始他这个就是亡失津液，那么由于已经到了脚挛急的这个情形。这个芍药甘草汤中的芍药啊，它是苦而微寒的这么一味药，它也能够对这个，我们桂枝汤里搁芍药，它与甘药合之它也是养液的。那么开始用这个药就没有这个乱子了，这个时候啊更作芍药甘草汤，吃这个药他脚就好了。底下这个看出这个病是有热了，“若胃气不和，谵语者，少与调胃承气汤”。他这个里边的胃不和不是个重要的，实际上开始心烦，他就是小便数，他是虚，这个不是阳明实结的那个厉害，经过上边的这种治疗，甘草干姜汤、芍药甘草汤之后一切病都好了。这个人呐还有说胡话，胃气不和，谵语，这个你也不要多用调胃承气汤，只能少少用，以调其胃气就好了，所以“少与调胃承气汤”。这个用

药啊，不是说一个方子怎么样，以量来调治这这也是一个方法。比如我们遇到一个病，头前那几个方子都是啊，你像麻黄各半汤啊，才刚讲的桂枝二越婢一汤啊，这种表邪非常轻，你不要用大剂药，少少给一点。那么这个调胃承气汤，虽然是一个整个方子，要少少给他一点就行，这就是调其量以适应这个疾病。这也是一个方法，不能说我们开个调胃承气汤让你整个还是一回吃那些，那他人就受不了了，他这里头不是那个实法，虽然谗语，谗语大便就干了，这个大便干是由于亡津液，不要那么攻，所以他说“少与调胃承气汤”。底下这个他是反过来说的，他说假若“重发汗”，就是说咱们给吃这个桂枝汤了，这是假若，没有这么糊涂的大夫，又自汗出，又小便数，还给人吃麻黄汤，他是假设说的，假设这个病，他是亡失津液，这是个主要的，你还大发其汗，而又加烧针迫急其汗，这个出汗也最轻了，拿烧针刺激他发大汗。要是这么来呀，这个病它也要四肢逆厥的，但是那不是甘草干姜汤能治疗的了，那非陷于阴证不可。这个虚极呀，就要从阳证转变为阴证了，阴寒重证了，那你非用四逆汤才能治疗呢。这个是个假设，后面这一段比这解释得好，我们把方剂再看一看，然后咱们再研究下面这一段。你们看看这个甘草干姜汤，甘草是四两，干姜才二两啊，这个干姜大概都用炮姜。这个四两啊，拿着这个十六两的秤，应该是四钱，啊，这个多了，这个药分一煎两剂，他煮取一升五合嘛，分温再服，匀两次，匀两次这个量就大了，古人一两合现在三钱，十六两秤，三四一十二，拿二除呢，还六钱啊，所以这甘草，拿十六两的秤啊就是六钱。那么干姜呢，是甘草的一半了，那个六钱，干姜就是三钱了，它以甘草为君药，为主药的。这个甘草又缓急迫，配合这个（干姜），所以辛甘并用啊，它配合干姜又是温中健胃，所以它是主要扶胃气，养津液，治这个四肢厥逆。四肢厥逆，没陷入阴证，陷入阴证非用附子不可，没到那个程度，所以用甘草干姜汤就可以了。如果你再使他大虚，非陷于阴证不可，只是用甘草干姜汤还不行，你

还得加附子，他说这个四逆汤啊就是这个。这个甘草干姜汤应用的机会也挺多，它也治小便数，你可知道，所以这个小便数呀，遗尿呀有用甘草干姜汤的机会，这就是说胃虚不能制下嘛，就是方才所说的这种情况。

这是个温中养液的药。芍药甘草汤，这个“白”字用不着，搁个“白”字当然也行了，旁的书上没有“白”字。芍药、甘草各四两，这个也是大量用甘草。芍药甘草汤应用的机会也挺多，它不止治脚挛急了，也治肚子疼。那么对于这个下肢软，它也治，所以古人把这个方剂啊又叫做“去杖汤”，去杖就是拐杖那个杖。脚，下肢软而无力，这个芍药甘草汤有治疗的机会。这个拘挛，我们这段讲的拘挛，拘挛更得用它了。下肢拘急，可以用芍药甘草汤。芍药主要是缓挛的，缓拘挛的。调胃承气汤，大黄、芒硝加甘草。你们看这个地方甘草的作用就知道了。咱们这三个承气汤啊，大承气汤是大黄、芒硝、厚朴、枳实；小承气汤没有芒硝，就是大黄、厚朴、枳实；调胃承气汤有大黄、芒硝，搁个甘草，所以甘草这个药对胃是有好处的。大黄、芒硝本来是泻下非常有力了，那么搁上甘草叫调胃，所以这个甘草看起来呀，起码有护胃的作用，保护胃的作用。就像我们讲的白虎汤（的粳米）是一样的，它是甘味的一种粘滑药，所以这个泻下它不重，你要配合厚朴、枳实呀，就是不搁芒硝，这个泻下也挺重，小承气汤也比调胃承气汤重。因为什么呢？你看小承气汤没有甘草，所以古人这个配伍啊从这个方剂中咱们也可以理解。

甘草呢，据说也没有那么大作用，但在临床上确实（作用很大），所以咱们少气呀什么的都要用甘草，也许与它这种缓急迫作用也有关系，从急迫证候也可以解释得通的。你看挛急也是的，脚，本来平常没有这个病啊，冷丁就是由于丧失津液，脚发挛急，这也是一种急迫证候，所以搁个芍药甘草汤，这个甘草同芍药量是一边大的，现在我们用都是六钱了，都是 18 克了。在这一点我们还可以体会这个，这

个甘草啊，小便数用它是正确的，大量用也可以的。如果这个人有浮肿，这个甘草啊影响小便不利，你看依着这个前后这个病啊，都挺适应的，这个病主要根源就是小便数，他本来是太阳伤寒，不应该出汗，由于胃虚不能治水，所以小便频数，影响他汗出，这个小便数在这一段是个主要的证候。这几个方剂都治小便数，甘草干姜汤也是的，这个小便失禁呐、遗尿啊，这个甘草干姜汤都起作用。我们后头还要讲这个苓姜术甘汤，就是甘草、干姜，再加上苓术，这个也治腰痛，治遗尿，都有用的机会。这个芍药甘草汤也大量用甘草，所以甘草不利于浮肿啊，要是浮肿啊，用甘草要加小心，影响到小便不利，更使水没有出路了。他由于小便数呢，这个甘草要用。但这个病都好了，他和那开始都一样，就由于心烦，微恶寒，表欲解，而阳明有内结的情形，他多少地有点谵语不愈呀可以给调胃承气汤。那么后头这个四逆汤是假设的，没有那么治的，假设你要是那么治了，那就变成一个阴寒的一种四肢厥冷了，那非用四逆汤不可。

四逆汤就是甘草干姜汤加附子，在这药量都轻了，不像上边用得重。四逆汤在后头三阴篇当中单独讲得最多了。这个干姜与附子搁在一起呀，温里的作用就大得多了。附子这个药啊偏于治下，像这个下利呀，那么它是温下元的，后世说它是入肾了，那也是根据部位上说的了，它是偏于治下。这个干姜偏于治上，所以呕吐什么都要用姜，不用附子。可是这两个药搁在一起呢，是彻上彻下，无处不温，所以这个四逆汤必须把这个干姜和附子搁在一起。那么古人也有这么说的，说这个附子啊，有了干姜，它才真热。那么就是这两个药配伍起来，这个温中回阳的作用才特别大，所以在三阴篇里头对这个四逆汤我们要着重讲的，现在理解到这儿就行了。在这一段，也不是用它来主要进行治疗。下边这一段，这个前后啊，又是像一节，又不像，但是后边的我认为解释得好，后边呢就把这个四逆汤抹去了。

李冠杰：这个条文在《康平本》和《宋本》之间有一些小的差别，

我们跟大家也都一一作个交代。一个是“反与桂枝汤”，《宋本》是“反与桂枝”，少了一个“汤”字；“咽中干燥”，《宋本》是“咽中干，烦躁”；《宋本》在“更作芍药甘草汤与之”之后，有“其脚即伸”四个字，《康平本》里边没有；“小与调胃承气汤”，《宋本》是“少与调胃承气汤”；“复加烧针，得之者”，《宋本》是“复加烧针者”，没有“得之”两个字。这条里边最后一个方剂，《康平本》里边不是四逆汤，叫“回逆汤”。而且它那个回字是一个老字（就是同志的同，里边把一和口去掉，换上一个己字，是那样一个字，或者是个巳字，是那样一个字）。实际上那个字在古代跟“回”是相当于同一个字，这就是一个回字。我们长期以来，都是按照《宋本》的叫法，叫做四逆汤。那么后边所有的“回逆汤”，我们都称作四逆汤。咱们在这儿跟大家说明一下就行了。

这个条文在《康平本》里边是顶格的条文。其中既有嵌注又有旁注。

下边我们解读一下：

这个条文之首，因为冠以“伤寒”俩字，所以说在历史上几乎所有的注家都在说，这是一个外感伤寒、里又有虚的这么一种疾病。但是，我觉得应该这么理解，我们应该整体地来看这个条文。条文里边有这么一句话，“反与桂枝汤，得之便厥”。说明这个病绝对不是伤寒。如果是伤寒的话，服桂枝汤不会出现这么严重的症状，不会出现“四肢厥逆”的症状。

我们应该怎么理解前边“伤寒”这两个字呢？本来的意思啊，患者的症状反应有表证的某些特征。实际上，后边的这些具体症状里边，“自汗出”，有汗出本身就不应该是伤寒。所以说在这儿，他就暗示人呢，我这儿说了不是伤寒。再深一步呢，作者有这方面的意思，初诊这个病人的时候，感觉他像是伤寒表证，但是整体来看，条文里边例举的所有的这些症状的话，你就不要当表证来治。提醒你尽管他像

表证，但是不要当表证来治。

“脉浮”，如果我们整体看的话，这个“脉浮”绝对不是表证的“脉浮”。在这儿不是主表，而是主虚。为什么主虚？我们下边还会进一步地讨论。

“自汗出”，也不是表虚证的“自汗出”或者桂枝汤证的自汗出。应该是一种虚汗，因为里虚得厉害，里虚得严重造成的表不固，出的一种虚汗。

“小便数”，具体在这条里边，是经方理论里边比较特殊的一种病理状态。这儿的“小便数”，指的不仅仅是小便的次数比较多这么一种情况，而是小便失去收摄。按我们今天的话说，就是遗尿，自己控制不了自己的小便，是这样的一种“小便数”。

如果鉴别一下的话，白虎汤证、真武汤证和肾气丸证，都有可能出现小便数的情况，但是它们的病理是不一样的。

白虎汤证的小便数，是因为里热严重造成整个身体呈现一种亢奋状态，整个的循环都快，所以体液的循环也快。以大量出汗的方式把废水排出来，或者是大量小便的方式给排出来，这样造成的一种小便数。

真武汤证的小便数，是下焦的机能沉衰，也是一种小便失去收摄，但是偏于里虚寒，更重要的是偏于脏器机能沉衰。

肾气丸也是下焦的机能沉衰，但是那个却有点偏热。

可是这个方证里边的“小便数”，比它们都要严重。当然不是说每一个患类似症状的人都有“小便数”。跟其他的方证联系起来以后呢，这个“小便数”，病理状态是什么？是中虚，就是胃肠道太虚弱了。尤其对下焦泌尿系统这个能量供应不足，造成泌尿系统的机能下降的这样一种小便失禁，是这样的一种“小便数”。这一种病理的“小便数”，我们可能只有在经方理论里边才能见到。

“心烦”，这儿的“心烦”也绝对不是因为里热而造成的心烦，

应该是一种虚烦。当然我们不排除他可能有一种热的倾向，但是也不至于会热到多么严重的症状存在，仅仅是轻微的有点热的倾向。

“脚挛急”，这个“脚挛急”，就是因为中虚得厉害，营养不能很好地吸收，出现了一种津血两虚的情况，就会造成肌肉组织失养，而出现“脚挛急”。当然临床当中不一定仅仅是脚挛急，也许会出现其他方面挛急的情况。

这个整个症状的排列啊，也非常有意思。他把“脉浮”和“自汗出”排到了前边，如果说经验不足或者说水平较低的一个大夫看的话，既有“脉浮”又有“汗出”，他就有可能认为这是一个桂枝汤证。其实我们今天啊，初学经方的人也经常有这样的倾向，就是说盯在一个症上，可能就认为这是一个表虚证，然后呢就给他桂枝汤。这“反与桂枝汤”，就明明白白地说这不是个桂枝汤证。

关于这个嵌注，整个的《康平本》里边嵌注的内容，总地说，水平要高于旁注的内容。这个“欲攻其表，此误也”，做了进一步的解释，解释得非常好。

“得之便厥”这一句话，应该是理解这个条文的一把钥匙。这是一个关键点，非常重要的一句话。那么，重要在什么地方呢？大家看，这个病人本来不是桂枝汤证，误当桂枝汤证，服了桂枝汤。病人服了桂枝汤以后有什么反应呢？“得之便厥”。四肢厥逆，仅仅是诸多症状的一个。这个人不会因为吃了桂枝汤，就仅仅表现为手脚发凉，不会。他还会连带着很多其他的证，这是一个典型的症状。

那么我们再进一步地去想：这到底是一个什么样的病人？我们按照字面所理解，这要是一个伤寒的话，是一个表实证，尽管喝桂枝汤属于误治，那也不至于到了四肢厥逆这么严重的程度。如果再想成另一种状况，他是半表半里证，不是表证，让他服了桂枝汤，他可能以前的证会略有加重，甚至于说维持以前的状况。小柴胡汤证下了以后，还有小柴胡汤证的，还可以给小柴胡汤嘛。是不是？有这样的条文。

这就说明，半表半里证误治了以后，也不至于会出现这样一种情况。那么，这是一种什么样的病人啊？这是一个里虚非常严重的病人。

我们再回头想一想“小便数”，“心烦”，“微恶寒”。那个“微恶寒”，乍一看，好像是表证，实际上那不是表证的微恶寒，里太虚了，营养不够，是这么出来的。我们怎么知道他里虚很重呢？因为他本来就有汗出，而且还是一种虚汗。服了桂枝汤以后，出汗的量会更大。这样会进一步地造成体液的丧失，疾病就会更加严重。

那么他出现了什么样的情况呢？就出现了“咽中干”。这就是津液虚得更厉害了，就算是有热，热也不是主要的问题。

“躁”，《宋本》里边写成“烦躁”。这都问题不大啊，相对地说，只一个“躁”字应该比“烦躁”还要重一些。

“吐逆”，这个“吐逆”啊，就是吃了桂枝汤发了汗以后，这个人津液虚、里虚得更厉害了。本来他就里虚，服了桂枝汤，把大部分的能量反倒要往体表来调动，他里边的能量就更少了，里虚得就更厉害了。那么他吃下去的东西都不消化了，不能消化就要吐出来，这就是“吐逆”。实际上，这样的人就基本上不怎么能吃东西了，而且还老想吐。

面临着这种情况，给了相应的治疗的办法，就是“作甘草干姜汤与之”。用甘草干姜汤来干什么呢？主要的就是治疗中虚，治疗胃肠的虚弱，使之能够快速增加人体的津液。那么这个时候存在不存在其他的疾病？肯定存在的。这个时候的主要矛盾，就是中虚，就是胃肠虚弱得厉害。甚至这个疾病能够致人吐血。大家想想这种情况下的吐血，没有明显的热，那么这种吐血纯属一种虚。虚到人体的浅表性血管都已经失去了正常的牢固程度了，就很容易破裂才造成吐血。

我碰到过这样的病人，现在我手上就有这样的病人。稍微再严重，就有可能危及到生命。在这个时候，其他的所有的都不重要了，先把胃肠功能给改善了。所以说用的药非常得简。这时还会有脚挛急什么

的，也没有把甘草干姜汤和芍药甘草汤合在一块儿用，而是分开用。把解决胃肠虚弱当做一个首要的矛盾来解决，其他的都要缓一缓。

后边有一个旁注：“以复其阳”。这个呢也没有太大的问题。

条文的下边，就论述到了在这种病理状态下出现的三种情况。同时给出了处理的办法。

“若厥愈”，喝了甘草干姜汤以后，四肢厥逆的情况已经消失了。

“足温”，就是脚已经开始恢复到正常的温度了。也就是胃气已经恢复了，胃气吸收的营养，可以达到四末，四肢的温度也逐渐地恢复正常。

这个时候，胃气恢复了以后，“更与芍药甘草汤”。用芍药甘草汤来干什么呢？来改善肌肉组织失养的情况，治疗身体挛急的症状。其实芍药甘草汤也有增加津液的作用，可以治疗津血两虚。

另一种情况，出现了胃气不和、谵语，就是说胡话。我们有理由相信，有的病人在起初的时候，本身就有里热的倾向，虽然不是特别得重。后来服了甘草干姜汤，甘草干姜汤毕竟还是一个偏温的药。那么为什么没有加寒性的药呢？因为那个时候，一点影响胃肠功能恢复的药都不能加，包括芍药都没有加。就是先解决主要矛盾，一定要把胃气先恢复起来。人体的所有能量都是靠消化道来吸收的，胃气一旦衰败了，人就没有救的希望了。所以那个时候，就算是有点偏热，也不要管它，先让他服甘草干姜汤。因为这个药本身就是温药，服完了以后他可能热得厉害，一直郁热着，胃气不和，可能会说糊话神智不太清。这个时候，少量地给调胃承气汤。“小与调胃承气汤”跟“少与”，没有什么区别啊。

这里边啊，隐含了两层意思：首先调胃承气汤可以治疗里实热，重点是治疗热，这是其一。另外一层意思，强调了用改变给药量的方法，来控制治疗的一个尺度。这一点也非常重要。“少与”肯定就比

原剂要少一些。少到多少，要医者自己来判断了。为什么要这样变化呢？病人本来就很虚了，现在又有胃热的问题，那么调胃承气汤是比较合适的。但是要喝多了，也能造成刚刚恢复的胃气再给损伤了，避免造成这样的情况，所以要“少与调胃承气汤”。

“若重发汗，复加烧针、得之者、四逆汤主之”。加了一个“若”字，对的是前边哪个茬口？条文一开始列举的那些症状：“小便数、脚挛急、自汗”，实际上那就是一个很虚的人。如果说对这样的人，你要是给他再重发汗，比如大青龙汤或者麻黄汤，那人肯定要出危险的。甚至说发了汗以后，觉得病没好，因为不对证嘛。觉得病没有好，又加烧针，强迫人再大汗出，那这个人就肯定会陷于一种重症。本来就很虚弱，再这样折腾，肯定就到了一种很危重的状态了。这时候就只有用四逆汤来治了。

这段条文里头，这么虚的病人，服了甘草干姜汤，后来又服了芍药甘草汤以后，基本上好了。所以说我们有理由相信，他应该是服桂枝汤之前，或者是服桂枝汤之后，或者是服甘草干姜汤之后，一再这样误治，都有可能造成这样的危急重症。这种重症的处理，恐怕就只有用四逆汤来解决了。

这个条文，整个论述的就是一种里虚重证经误治以后，可能出现的变证及其治疗方法。整个条文就是论述的这么一种情况。

下面，我们把这个条文再作一个小结：

临床中存在一种情况，因患者的症状反应与表证有些类似，所以易被辨证为表证而发生误治。例如，患者表现为“脉浮、自汗出、心烦、微恶寒”时，就与表虚证颇为接近，但是同时还有“小便数、脚挛急”等症状，则说明以上诸证都属于里虚证的反应，而非表证。临床当中却常有医者误将此类疾病辨为表虚证，而误以桂枝汤发汗，其结果是由于服药后汗出更甚，不但前证得不到治愈，更可能因里虚，加之津液损失而出现“四肢厥逆、咽中干、烦躁、吐逆”等症状，此

时应该用甘草干姜汤先治其里虚重证，并同时恢复津液；如果服药后四肢厥逆等里虚证消失，然后再用芍药甘草汤治疗脚挛急等症状，患者即可痊愈；如果患者本来有里热，则可能出现胃气不和的情况，表现为“谵语烦乱”等症状的，可少量给予调胃承气汤即可；对于如此虚弱的病人，如果医者误予发汗重剂之后，见病不愈，又误施烧针，而一误再误的，必会导致患者处于危急重症，此类情况只有用四逆汤方可治愈。

这个条文涉及四个方剂，这四个方剂论述的程度不太一样。我们今天就对这四个方剂，详细地通看一遍，把这些方剂做一个比较全面的了解，为我们正确地理解其他的条文打下一个基础。

我们第一个，先说甘草干姜汤。甘草干姜汤就两味药组成，甘草四两，干姜二两，分温再服，这是两次的治疗量。甘草这味药的寒热倾向不是特别得明显，甘草有补里虚的作用，再一个能增加津液，还有一个缓急的作用。在这个方剂里边主要就是补虚、增加津液。干姜是一味温性的补中虚的药，是一个热药，健胃作用非常明显。

下边呢，我们看看这个方剂的方证。方证分这么几项：一个是症状，再一个是舌质、舌苔，另外一个脉象，分这么几大项。有统计的至少是 84 个案例以上。

在这 84 例里边，四肢厥逆 38 例，脘腹冷痛 28 例，眩晕 24 例，面色苍白 21 例，倦怠乏力 16 例，这都是比较典型的症状。腹泻 14 例，呕吐 13 例，喘促 11 例，少气懒言 10 例，纳呆食少 10 例，咳嗽 10 例，遗尿 7 例，恶心 6 例，咳痰稀而白成泡沫状 6 例，衄血、吐血、便血之类的症状各 6 例以上。

前边那几个症状是比较典型的，后边这些症状呢，虽然不是很典型，但是我们从中能看出什么？不管是经方的条文也好，还是我们在临床当中也好，都不要把经方的这些方证，把这些症状机械化。经方的这些症状不是一个固定的症状群，而是综合的症状的集合。

舌质：最多的是淡舌，还可以分淡嫩舌、淡胖舌、淡紫舌。占总数的 96.3%。这个舌质呢，是能够作为一个定向的指标。淡紫舌有 2 例，确确实实有。

舌苔：大部分都是白苔，有的是白滑苔，有的是白润苔，有的是白腻苔，有的是白干苔。

脉象：脉迟 41 例，脉沉 36 例，脉细的 21 例。

现代疾病：急慢性胃炎、肠炎、胃及十二指肠溃疡、上消化道出血、慢性支气管炎、肺气肿、肺结核、肺炎、肺不张、冠心病、心绞痛、风心病、肺心病、子宫功能性出血、附件炎、鼻衄、自汗、厥逆、眩晕、鼻渊、劳淋、虚劳、遗尿，有些呢属于中医疾病的范畴。这个方剂还可以治疗符合这种方证的肺部的一些疾患。

通过上面这些疾病，我们就不难看出涉及到了很多不同部位、不同器官的一些不同性质的疾病。尽管涉及的疾病很多，但是不能离开一个原则，不能离开一个基点。就是存在着胃肠功能特别虚弱。

这个方剂跟四逆汤比较接近，就是没有附子。但是和四逆汤的治疗之间还是有比较明显的区别的。从刚才对方剂的分析，这个方剂主要治疗的是里虚，很难说这个时候人还处在一个阳证的状态。但是呢，就算是进入阴证了，也没有用附子。我们就应该理解，这仅从里虚为矛盾的主要方面的时候，附子不太合适。尽管附子可以振兴人体几乎各个部位的机能，恰恰在这个方剂里面没有用附子，道理上说应该用的，但他没有用。肯定这个时候用四逆汤的话，恐怕对胃气的恢复多少有一点影响。

我们把方证、舌象、脉象都了解了以后，下边我们再看看从病理上，我们应该怎么认识。我们刚才说了，这个病的一个基点，就在于人体的消化系统出现问题了，出现了很虚弱的这种情况。在这种病理状态下，哪一个部位、哪一个器官虚弱得最厉害，首先从哪个地方出现严重的问题，先暴露出问题来。首先出现吐逆，不能吃饭了。

另外呢，就是上消化道浅表的血管出现一些破裂。这时候就会出现吐血；甚至鼻子也有可能出血。但是这种出血不是因为有里热造成迫血妄行，不是那种，这个没有那么大的热，主要是一个虚的问题。如果把血管理解成胶皮管的话，像胶皮管那个强度降得很低了，稍微一动就破裂，里边的水就要流出来，就这么一种。

这个呼吸系统的疾病，表证、表实证可以造成呼吸道的一些的疾病。是因为表实了，肌表的功能丧失，增加了肺的负担。这个从病理来说，不是这样子。这儿就是因为里虚了，胃肠吸收的营养不足，导致肺部呼吸系统营养供应尤其不足，无法维持正常的工作状态了。所以会造成一些咳喘，一些肺部的疾病。因为呼吸道不停地在呼吸，在正常的情况下，吸进去的一些致病因素能抵抗住。但是虚弱了以后，弱了一定的程度，没法抵抗，就发生一些炎症，就会发炎。

其他的，循环系统的疾病，泌尿系统的疾病，包括生殖系统的一些疾病。这些疾病都是这么一个机理，就是因为中虚，使得能量供给不足。

我们研究经方要时刻想到这样的问题，相同的病理状态，若出现在不同的患者身上，会出现不同的疾病。我们怎么去理解？怎么会形成这种状态？这点很重要。这跟其它任何医学都不一样，而且这还是其他医学解释不了的。现代医学，传统医学都没有这种概念。

为什么会出现这种情况呢？我在这儿跟大家打一个比方：一棵苹果树，不管这个苹果树的健康状态好和不好，没有哪一棵苹果树上的苹果，都一般大，没有这种情况。为什么会出现这个问题呢？那个小个的，肯定得到的营养就少，虽然说在同一棵树上。也很难说离母枝干越远的苹果就越小，那也不一定。人体实际也存在这种情况，这就是人体能量分配存在一种不均衡性。如果均衡的话，人就不得病了。就像苹果一样，哪个苹果得的营养最少，个头就最小。那么放在人身上，哪一个器官得到的营养成分少，健康状态就越差，就越容易发生

病变，这一点是非常重要的。这个问题你想通了，经方里边很多问题都可以顺理成章地能够解释通。

第二个方剂是芍药甘草汤。芍药甘草汤在《康平本》里边没有方剂，也没有方后注。《宋本》里边有这个方剂：“芍药甘草汤方：白芍药、甘草炙各 4 两，右二味以水 3 升，煮取 1 升 5 合，去滓，分温再服”。查遍了《康平本》也没有，《金匱要略》里边也没有这个方剂。但是这个方剂是一个常用的方剂。

这方剂只有两味药组成，芍药是一味偏于寒性的血分药，我把它叫做血分药。有治疗因肌肉组织失养而发生的拘挛或是痉挛或是疼痛这种症状的特能。甘草在这方剂里边，基本上还是那些个功能。

方证：有统计的医案是 205 个。

症状：

疼痛 142 例，其中腹痛 76 例，腿痛 24 例，腰痛 16 例，头痛 14 例，足跟痛 5 例，面部疼痛 4 例，上肢疼痛是 2 例，牙痛 1 例。

痉挛 49 例，包括痉挛、挛急、肌肉跳动、抽动、抽搐。肌肉跳动，应该和痉挛还是有一点区别的。

按部位，下肢痉挛 32 例，全身抽搐 8 例，上肢痉挛 4 例，面部肌肉痉挛 3 例，腹肌痉挛 1 例，咽中痉挛 1 例。

舌质：红 90 例，淡 47 例，这是比较多的。总体来看，芍药甘草汤的舌质的变化，与常人的舌质没有明显的差别。

换一个角度说，中医里边有很多侧重脉诊的，侧重舌诊的。如果是侧重舌诊的，或者刚刚学会了舌诊，要是遇到一个芍药甘草汤证，你等于说是无证可辨。

舌苔：薄 40 例，白 55 例，黄 24 例，与正常的舌苔差别也不是很大。芍药甘草汤整体来说，还是偏于寒性的，这类的病人有点热的倾向是正常的。

脉象：弦脉 93 例，细脉 58 例，数脉 46 例，还有沉脉、涩脉、

微脉、濡脉，紧脉、缓脉、虚脉、弱脉、大脉、小脉、滑脉、迟脉、急脉、有力的脉，无力的脉等。几乎什么样的脉象都有。前面这三个脉象是比较有代表意义的，因为出现的频率比较高。

大家看啊，这个方剂就出现了一个特点，要是辨脉诊、舌诊的话，恐怕特征性的不是很集中。

现代疾病：腓肠肌痉挛、不安腿综合症、膈肌痉挛、胆绞痛、肾绞痛、尿道痉挛、乙状结肠痉挛、神经性血管痉挛、风湿性舞蹈病、癔症性抽搐、肋间神经痛、胃痉挛、胃脘痛、腹痛、痛经、胃及十二指肠溃疡、胃扭转、过敏性肠炎、肠粘连、慢性肝炎、急性水肿性胰腺炎、胆结石、面部抽搐痉挛、脑中风后肢体痉挛、脊强直症、血栓闭塞性脉管炎、血管平滑肌痉挛、血小板减少或过敏性紫癜、支气管哮喘、特发性肾出血、慢性肾盂肾炎、关节损伤、骨质增生、股骨头炎、腰扭伤、乳腺炎、睾丸酮性不孕症、荨麻疹、风湿性关节炎。

说个病历。部队上的一个战士，他家是我们这儿的，他的一个亲戚在我这看病，跟我提起了这个事。说他最近出现胃疼，平时呢老是隐隐作痛，只要一活动就疼得厉害。他在部队上跑到军队医院里边去治，医生跟他说，你这是胃痉挛，没有别的办法，你只能是做手术。他的亲戚就跟我说了，我就说，你告诉他千万别做手术，让他跟我联系。这样呢，晚上跟我打一个电话，在电话上我就问他，结果呢，没有问出明显的症状，除了隐隐作痛，每当运动的时候他就疼得厉害。大家想想他在部队上因为搞训练呢，他应该说是挺痛。第二天我就让他亲戚给他发药，发的是芍药甘草汤的原方，原比例原方，芍药甘草各半。一共给他发了 10 剂，一天喝两剂，也就是五天的。前天他给我打电话，说他收药以后，喝到 3 天，还剩了两天的，喝了三天就好了。他这个亲戚就觉得太奇怪了，太神奇了。我所以这样给他药，一个是我在电话问他没有其他的症，这是其一；再一个年龄又比较年轻，平时又没有别的病，而且，部队上诊断又是胃痉挛，胃里边没有

其他的病，应该就是这样的病。我们看啊，这个方剂虽然在经方的书籍里边论述不多，但是，它却是一个常用的方剂。

前一段时间我跟大家交流的时候我曾经说过，用它来治不安腿综合症，吃下去就好。

还有跟我在一块平时晨练的一个人，他也是，这几天老肚子疼，我就给他这个药，让他一次喝一点，我给他的量非常小，大概就是一克到两克之间的样子，他吃了几天就好了。然后他跟别人说：“他那个药就那么一点吃了就好了，再一直没有犯过”。

那么我们怎么去理解这个方剂？这个方剂治疗的是一种什么样的病理状态？我觉得啊，芍药甘草汤的君药应该是芍药。那么治的是什麼病啊？要按经方辨证来说，是津液又虚血液又虚。按照我们今天的认识呢，就是我们人体合成某种营养成分的功能不足了，造成肌肉组织缺少这一类的营养物质，就会发生痉挛或者疼痛之类的疾病反应，就是这个样子。

我为什么这么去理解呢？你看这个病啊，阴阳属性肯定是一个阳证；寒热倾向也不是特别明显，稍微有一点偏热；虚实的倾向也不是特别得严重。但是，津虚血虚也不是很重。那么这个人为什么会出现肌肉痉挛，或者疼痛这一类的情况呢？大家去看一看，甘草肯定是治不了这个病，主要的功能就在于芍药。

我们再去看其他的方剂，芍药在其他方剂里边是一个什么作用啊？当归芍药散，这是一个比较典型的方剂。当归芍药散治什么啊？治停饮。在停饮的同时又有血虚，血虚水泛嘛，他又有血虚。但是血虚，我们想啊，要如果说单纯的血虚的话，当归川芎治疗血虚的作用应该比芍药要明显。因为你再去联想其他的方剂，当归川芎应该是治疗血虚最有效的药物。那么芍药在里面治什么呀？不是说“妇人腹中痛”嘛，就治的这个疼。不仅仅是女性病人肚子疼这一种，还治各个部位的疼痛，或者是痉挛。从这儿我们就能想到了在芍药甘草汤里边，

它也是帮助改善血液成分的。这个血液成分里头，不仅仅是血液本身虚，还缺少一种物质。芍药就能增强人体合成这种物质的功能。他一定应该是这个样子。那么具体是什么？我们解释不了。但是从其他的方剂里面我们可以佐证这个事。

这儿呢又同样带出了刚才的问题。如果是人体合成这种营养物质的能力差了，为什么他不全身都抖啊？这就是因为营养物质分布的不平衡。就刚才我们比喻的那个苹果树的问题，还是那个问题存在。

而且芍药甘草汤在临床当中，还有比较特殊的一个功能，治疗打嗝，就是膈肌痉挛。我在网上看了一个帖子，他说用芍药甘草汤治好了打嗝。我马上就联想到了芍药甘草汤有治疗膈肌痉挛的这种功能，我想应该可以治疗打嗝。巧了，我有一次饭局，喝了一点凉的啤酒，就刺激到膈肌了，就开始打嗝，回到家了以后老打嗝。恰好我手头上有芍药甘草汤，大概喝到将近 5 克的样子，这对我来说是最大的剂量了。我喝下去一会儿，这个嗝就不打了。但是胃里边，还是不特别舒服吧，反正是总觉得有点怪怪的。就是说它能治打嗝。

那么这儿又带出另一个问题来，旋覆代赭汤也治打嗝。从药物上分析你就知道了，旋覆代赭汤治的是里虚气逆，而芍药甘草汤治的是津虚血虚。所以说它们是不一样的。如果这个人既有胃虚气逆，又有血虚津液虚的问题，可以把这两个方剂合到一块儿，绝对应该是有效的。这是芍药甘草汤。

第三个方剂呢，是调胃承气汤。调胃承气汤方剂在《康平本》里面呢，出现在第 70 条，在这一条里面没有方剂。这个方子有三味药组成的，大黄、芒硝、甘草。大黄这味药啊，主要功能就是祛实，而且祛实呢，挺有意思，跟什么样的药配到一块儿，祛什么样的实。跟细辛和附子配到一块儿的话，还可以祛寒实。尽管是一个寒性药，要跟温药配伍的话，可以祛寒。在经方里边大部分都是用来祛里实热。芒硝呢，也是一个寒性的祛实的药。芒硝的作用主要局限到一个消化

道，一些祛瘀血的方剂里边，常常会见到大黄，但是这一类药里边肯定见不到芒硝。不是没有那个作用，主要是作用于消化道。甘草在这儿呢，主要的起到一个缓急补中的作用。

这三味药合到一块儿呢，理论上说是祛里实热。但是这个方剂的重点是祛里热。能不能祛实？也能。但是祛实的作用相对于大小承气汤的话，就不及大小承气汤。咱们可以做个鉴别，小承气汤主要是治里实，也治里热，但偏重于祛实；大承气汤，是实热皆祛，是一个峻剂。而调胃承气汤，偏重于祛里热。

症状：统计的医案是 90 例，便秘 62 例，发热 45 例，腹部硬满 44 例，小便短赤 32 例，烦躁 30 例，口渴 24 例。症状相对说还是比较集中的。

舌质：红舌、绛红舌、淡红舌、胖大舌。

舌苔：黄燥、黄腻、苔斑、薄黄、厚腻、薄黄腻、黄。

脉象：滑数脉。

现代疾病：急性胰腺炎、黏连性肠梗阻、急性肠梗阻、乙型脑炎、败血症、流行性腮腺炎、传染性软疣、糖尿病、急慢性胃肠炎、急慢性胆囊炎、细菌性痢疾、结肠炎、荨麻疹、慢性肾炎、正副伤寒、急性肝炎、肺炎、脑血管意外、阑尾炎、结膜炎、角膜炎、咽喉炎、口腔炎、化脓性扁桃体炎。

从病理上分析啊，就是因为人体的机能过于亢奋，呈现出里实热的病理状态下，人体的某些组织器官恰恰处于比较弱的状态的时候，无法适应人体亢奋的环境，就首先发生病变。这一类情况是典型的阳证。

我再跟大家说一种情况，可以帮助大家去理解这个方剂。常喝酒的人，喝酒喝吐了，吐完了以后胃里头挺难受，又满又灼热。少给他一点调胃承气汤，一会儿他胃里就会舒服很多。

下面呢是四逆汤。四逆汤的方子，《康平本》里边出现在 323

条。四逆汤就是甘草干姜汤的底子加了生附子。也就是人体整体已经陷于阴证，陷于沉衰的这么一种情况。附子可以振兴人体的机能。

这个方剂对应的就是一种里虚寒的阴证，而且是一种重症。

症状：四肢厥逆、腹痛、胃寒喜热、神疲、面色苍白、腹泻与呕吐、发热、小便清长、头晕、周身乏力、腰膝酸软、食欲不振、神昏、短气、头痛、便秘、面色晦暗、心悸、汗出。症状是相当的繁杂。

舌质：淡嫩、淡舌有瘀点、红舌、紫暗、暗淡、镜面舌。

舌苔：润泽舌苔、薄白、白厚腻、滑而青、无苔或者少苔、少薄、黄。这儿呢出现有黄苔，按说四逆汤证，黄苔好像跟这个方证呢有点矛盾了，但是提醒我们在临床当中应该全面地来看，不能因为这一个证而造成我们误诊。像四逆汤证这样的病一旦误治了，就有可能出医疗事故。

脉象：沉脉、迟脉、细脉、弦脉、微脉、紧脉、浮脉、缓脉、弱脉。

现代疾病：麻疹、肺炎、感冒（四逆汤证，会以这样的浅表性疾病的形式反应出来。这个时候也不能治表证，应该治里）、冠心病、心肌炎、心脏骤停、风心病、肺心病、心力衰竭、心肌梗塞、病态窦房结综合症、急慢性胃肠炎、胃下垂、痢疾、重症黄疸型肝炎、肺气肿、支气管哮喘、咽痛、口疮、鼻衄、休克、疟疾。

病理：人体整体已经陷入一种沉衰的状态。

我这儿呢有一个案例，我觉得跟大家说一说，大家对这个方剂的印象比较形象一些。这大概是三四年以前了吧，我去看一个病人，在医院病房里边，护士长说李老师来了，就把当时上班的护士都叫到办公室里边，让中医给看看吧。我就挨个看，其中有一个护士，年龄也不大，她说她常年手脚冰凉，自己一点精神都没有，体格弱的时候，她老公往家里边带几个客人，晚上在这吃上一顿饭，第二天她起床都成问题，就是累着了。在医院检查不出来什么疾病，就跑到山东省二

院，没查出什么病，她老公就有点着急了，直接就去北京了。在北京看完了以后，北京结果也是一样，各项指标都正常，没有病，没办法就回来了。回来就正好有这么个机会看到我，我就给了她四逆汤散剂。她吃了几天以后啊，感觉精神什么的好多了，吃饭也好一些了。好了一段时间，正好她例假来潮，她就马上给我打电话，说我昨天晚上例假来了，那个想吐，身上一阵冷一阵热，特别难受。这就是说她基本上摆脱阴证了，出现了半表半里证。然后我就给她小柴胡汤。考虑她四逆汤证还不知道是不是彻底恢复，我就给了她三天的小柴胡汤。结果到第二天她又给我打电话，她说我吃了药以后啊，从来来例假没有来过这么多，把单子都给污染了，她说我现在啊，觉得浑身都轻松了，精神也好了，也想吃饭了。后来，她班上的那个同事说她，你以前谁也不理，跟谁也不说话，你现在叽叽喳喳地说那么多，跟换了个人一样。你是不是以前是装的呀？就出现这种情况。

通过这四个方剂，我们也归纳一下，看看有什么样的规律性。

一个是，每一个方剂都有可能治愈多种疾病。但是必须得在具有这个方剂的适应证的前提下，你才有可能治愈。不管你得了什么病，现什么方证，就应该用什么方子来治。

第二，每一个方剂的适应证都不是一个固定的症状群。经方方剂对的不是一个固定的症状群，而是动态的复合的症状反应的一个范畴，是这么一个范围。要想用好经方，你就得综合地去辨证，而不是要盯在某一个症状反应上。

第三个，任何一个现代疾病和一个单独的症状反应，都不能单独地与方剂建立对应关系。比如胆囊炎，能治疗胆囊炎的药很多，光经方里边就有 40 多个方子，所以说没有这种规律存在。一个单独的症状，也没法和任何一个经方方剂建立一个固定的对应关系。

那么经方靠什么用呢？我知道这个人是什么病，我也知道他是一些什么症状，但是症状又不够典型，或者说这些症状本身就是一些动

态的，这个人出现这些症状是用这个方子，另一个人出现的跟这个症状不太一样，也用这个方子。那么我怎么来确定呢？不管症状多么复杂，只要是应用经方辨证体系（表证、里证、半表半里证；血证、水证、气证；阴证、阳证、寒证、热证、虚证、实证）辨证，你只要是把这些东西辨清了，症状再怎么复杂，你最终也能确定一个治疗方向。而且这是一个正确的方向，到最终确定方剂还是要靠方证。

问曰、证像阳旦、按法治之、而增剧、厥逆、咽中干燥、两胫拘急、而谵语、师曰、言夜半手足当温、两脚当伸、后如师言、何以知之、答曰、寸口脉浮而大、浮为风、大为虚、风则生微热、虚则两胫挛、病形像桂枝、因加附子、参其间、增桂令汗出、附子温经、亡阳故也、厥逆、咽中干、烦躁、阳明内结、谵语烦乱、更饮甘草干姜汤、夜半阳气还、两足当热、胫尚微拘急、重与芍药甘草汤、尔乃胫伸、以承气汤微溲、则止其谵语、故知病可愈、（30）

胡希恕：这个 30 条，问曰：证象阳旦，按法治之而增剧，厥逆，咽中干，两胫拘急而谵语。师曰：言夜半手足当温，两脚当伸。后如师言。何以知此？这是一段，这是故意设一个问答，他解释前边这个问题，这个阳旦啊，桂枝汤的别名叫阳旦汤。他是根据那个证候像阳旦，像桂枝汤，那么按法治之呢不但不好，而且增剧，变成“厥逆，咽中干，两胫拘急而谵语”。两胫拘急他根本就有的了，脚挛急呀，而人也说胡话。这个呀，我们上边他是搁个，若胃气不和谵语，他是搁后头了，这个可见，开始就是经过服过桂枝汤之后，这个谵语就发生了。这一段是这个样。那么当时呀，就是这个先生这么说的，说到

夜半啊，手足当温，两脚当伸。那么之后的结果呢，同这个先生说的话是一样的，你怎么知道的呢？他底下就是解答了。“答曰：寸口脉浮而大，浮为风，大为虚，风则生微热，虚则两胫挛，病形像桂枝，因加附子参其间，增桂令汗出，附子温经，亡阳故也”。它这个病开始呀它就是个虚证，他说寸口脉浮而大，我们这个前一段只说浮了，这个浮大其外，而内里头它是没有的啊。作为浮，他是有外感了，他说浮为风，大为虚。这个大脉呀，如果这个脉大，按着里头滑，那是实热了，是啊，脉大。它这个里头当然不是了，不禁按，所以说大为虚。那么呢有了外感了，他当然身微热。那么由于虚呢，指什么虚呀，就是津液虚嘛，两胫发挛。这个病形啊由于这个脉浮、汗出，像桂枝，因加附子参其间。那么就是由于他这个汗特别多呀，头前不有一个吗，说太阳病发汗，遂漏不止，有那么一节，他就也因为那一节，他说桂枝汤他这个津液太虚呀，唉，用桂枝加附子，就是用桂枝加附子汤。那么又把这桂呀也增加了，好解其表，他这都是错的，附子温经，亡阳故也。这个桂枝配合附子，这个附子本来它是一个温经药了，那么再增桂，那更令汗出了，那更使之亡阳了，亡阳就亡津液了，所以他才变成“厥逆，咽中干，烦躁，阳明内结”。

阳明内结就是由于津液丧失太多，内里结实了，就实在的实啊，所以他谵语烦乱。那么，这个时候可以给他使甘草干姜汤。甘草干姜汤在这里头它是简说的，没说呕吐啊。那么虽然他说是个阳明内结，谵语烦乱，他主要由于虚啊，这个虚，津液特别虚，使的胃不和，那么这个时候还是救津液要紧的，讲阳明篇就有了。我方才所说这个，就是这个脾约了，他古人说脾约什么意思啊？古人他是这么看的，脾为胃行津液，说胃呀光消化了，这个津液往外送啊它没这个本事，它得脾（帮助）。那么如果胃里头啊，没有津液可输送了，所以这个脾呀受了制约了，古人这么看的，这个看法当然是不一定对了，现在咱们也不必这么理解，它就是由于津液丧失太多而胃里干，这个你不要

先治胃，你还是要想法子调胃而滋阴液，所以他用甘草干姜汤，这个谗语都得管。那么吃了这个药之后呢，夜半阳气还了，这个两足应该温了，这个“夜半阳气还”这句话呀也要不得，这古人的看法这都是，古人认为呀，一过了这个。。。。。。。。（音频丢失）。不到夜半，你白天吃了这个药也一样好病，两足当热。那么但是这个津液还没完全恢复啊，只是把这个四肢厥冷治了。“胫尚微拘急，重与芍药甘草汤，尔乃胫伸”。吃完芍药甘草汤之后，“尔乃”就是不久，这个脚就好了。那么这时候这个谗语烦乱不止啊，这时候你再稍用调胃承气汤，以承气汤微溏，这与头前那个“少与”一样的意思，微微地呢大便稍稀一点，你别让他大泻下，则止其谗语，那谗语就好了。他说由于上边的这个我的看法都正确，所以这个病它是可以好的。这一段它说明呢，比上一段说明得好，同时在这里我们也看出来，小便数，桂枝汤吃不得，桂枝加附子（汤）也吃不得，所以凡是小便数，决不可发汗。这个在临床上啊也常遭遇的事情，所以这个问病啊非详细不可，你说人闹感冒，他是憋不住尿，那么频数地很，你就这个我们常遇到，他也有感冒也有泌尿系感染这类的病，拿现在病名说，小便非常频数，你先不要治感冒，你先治小便频数就好了。你先给他吃猪苓汤，你就先别管他那感冒。你先要是发汗啊，那非越来越坏。他这个丧失津液，你再发汗就是一个大忌。

至于它这两段，也都针对桂枝汤讲的，所以我们这个辨证啊，不能片面看问题。这个桂枝汤，它是治发热汗出的，但是还有旁的证候，你都得全面看问题，你不能一遇到这个发热汗出你就用桂枝汤，这也是往往治成错误的。所以他有个小便数，造成这个自汗出，虽然脉浮，你也不能用桂枝汤，尤其他要是有了这个明显地这个津液竭于里的一种反应，那你更不能用了。你像这个脚挛急呀，心烦啊，这里它已经由于津液的枯燥，他胃不和都已经有了嘛，你还给人家攻表那还行了？所以这个时候这个病啊搁在我们现在看，你比如咱们在临床上遇

到这个病，那么脚挛急先就应该使芍药甘草汤。要是不好呢？不好这个病啊，有用这个，你像咱们后头就要讲了，像用这个你看桂枝汤加芍药加人参，有用这个机会，他要有表证仍不解，那个它是治里虚的。也有用白虎加人参（汤）的，病人如果他要渴呢？他里头热相当盛了，你白虎加人参（汤），这个石膏啊也治小便数啊，也治自汗出。所以张仲景他为什么在头前他不给你明说呢？他不注重这个。那么我们关于这些的方剂的治疗在后头都有的，所以在这一节呀后世的医家也都说应该用什么，大家直打架。他这个有很多，它就是在在一个可戒之点就是不能够发汗，它主要的这个，讲这节的这个用意，不是说这个证候应该用什么药，还没讲到这个地方，所以我们就这一段的前后看，当然是以吃芍药甘草汤为最好了。芍药甘草汤也能治小便数，也能够所谓育阴生津啊这个，他有甘草这个药嘛。那么，这个是比较正确的。但是张仲景这个书不注重这一点，他注重后头。他这一点提出来的最好，你像甘草干姜汤。

那么这里这个津液虚，是由于胃的关系。这个时候你不理胃呀，你光滋阴，越滋阴这个胃越坏。咱们滋阴都用生地、麦冬这类药了，你越滋阴，尤其生地，它碍胃的。胃越不好，津液不会生的，哪来呢？他明明是由于胃虚，尤其治误了马上就吐，那你再使生地，他不更吐了，所以这个治病啊，不是只凭脑子想，你最终还要从现实证候上看问题，所以中医这个辨证啊是很有道理的。你不能片面看问题，更不能主观。那么这一段他讲得较比好，明明是津液大虚，他用甘草干姜汤，这在后世上数不尽的，尤其《医宗金鉴》上也说，他说这个津液虚，还用辛甘药。其实这个辛甘药用得是对的，你得看什么时候，你比如咱们常说甘温除大热。甘温除大热不是说遇到大热就用甘温，这是错的，可是有一种需要甘温来解大热的，你非用甘温不可。你比如桂枝汤就是呀，咱们这个桂枝汤讲了不少了，后头还有。是桂枝汤没有不发热的，可它有一个条件，这个脉必须弱，人必须有津液丧失的这

种情况。在这种情况下你用它，那是百试百验。随便一个大热，你像白虎汤证也是，你像大青龙汤证也是，那个他脉浮紧而无汗，你吃上桂枝汤就坏了。所以“以甘温除大热”这句话就是有毛病，它得遇到它这个适应证，是应该以甘温除热的这种大热，你用它就是对了，否则就是害人。你比如说甘草干姜汤，它能够治这个津液虚衰的这种厥逆，你可不能遇到厥逆就用甘草干姜汤，那也是不行的。他又呕吐，这明明是胃的关系嘛。烦躁，他一现就现这个急迫的情况，你用甘草干姜汤就对了，而且这个原病小便数始终存在，你可知道，他又小便数，你用它不是蛮好嘛。所以中医这个辨证啊，尤其这个书，那严得很，不像咱们随便，（大）原则上地看个问题，就来自己想方子用药是不行的。咱们今天就讲到这了。

李冠杰：第 30 条的论述基本上跟第 29 条情况说的是一种情况，但是或许作者有对这一类的疾病又有了新的临床体验，你看它的区别在哪儿呢？

第一个就是他用的方剂，那边说的是用的桂枝汤，这儿用的是桂枝加桂汤，而且桂枝的量加大了。他也感觉到这是一个虚证，虚得厉害，用桂枝加附子汤行不行？他用桂枝加附子汤，桂枝又加了量，结果做了调整也不行，这是一个和第 29 条不同的地方。

第二个地方就是，因为用了桂枝加附子汤，而且桂枝加量以后，这个方剂就比单纯的用桂枝汤要温热的多，这个时候患者里热的倾向就比较重。所以说我们明显能感觉出来，能看出来：他的患者表现的症状像谵语之类的症状出现得早、表现也重，这又是一个。

第三个就是对脉象的论述，它这个条文秉承了王叔和的一贯做法，比较主观，也比较机械。你可以具体看一看，你比如说“浮则为风”，“浮则为风”就很机械了，浮脉不一定是主风的。尤其这一条里边，它不应该主风，要是主风的话，你那个桂枝加附子汤就应该管用了，这个地方的浮脉应该主虚，他犯了机械的毛病。再一个“大

则为虚”，事实上这个大脉也不一定全来主虚。所以说在这个地方，如果说浮大的脉是一种虚证，似乎还比较能说得过去。但是王叔和他一直就是这么一种，说是比较机械。所以说他这种脉象应该说是他凭空的在上一条的基础上又加了一个大脉。实际上这个病人是不是会出现大脉呢？恐怕也难讲，其实我们在临床当中，要如果说像这个病人不出现大脉，也未必不是这个病。是不是？咱们刚才那个临床统计，是不是已经能说明了问题？不一定这个病准是一个浮大的脉。所以说把脉强调到这个程度，是完全没有必要。

但是这一条也有它有意义的一方面，我总结这么两点：

一个是这个条文它证明了第 29 条论述的服桂枝汤之前的这些症状，你服桂枝加附子汤也不能治，它证明了这一点。他感觉出这个人虚来了，他觉得应该加附子，然后加了附子以后，依然是人出现了那样的病情恶化的情况，这是一点，又多了新的佐证。

第二个就是在里虚和里热同时存在的情况下，因为它这一条里边论述了热的倾向比较明显了，里虚证依然，就具体到这一个病例，里虚依然是主要的矛盾，还得先把里虚治了。即便是他里热的厉害了，你再去治热，你也得先解决里虚的问题，这一点倒是再次强调了经方顾护胃气的这么一个理念。

大阳病、项背强几几、无汗恶风、葛根汤主之、（31）

葛根四两 麻黄三两去节 桂枝二两去皮 生姜三两切 甘草二两炙 芍药二两 大枣十二枚擘

右七味、以水一斗、先煮麻黄葛根、减二升、去白沫、内诸药、煮取三升、去滓、温服一升、覆取似汗、余如桂枝法、将息及禁忌（注）诸汤药皆仿之。

胡希恕：这个项背拘急，这个“几几”是一个状词。这就是脖子（头颈）全身左右运转不自由，项背拘急的厉害。这个字本来是形容小鸟学飞的时候，羽毛未丰呢，它飞不起来，伸着脑袋那个样子。就叫“几几”那个形状。那么太阳病就是头项强痛而恶寒，就是这一类的太阳病，如果项背强有“几几”的样子，无汗恶风，葛根汤主之。他这个方剂，就是桂枝汤加麻黄加葛根。本来他是个桂枝汤证，所以他恶风呢。我们用这个方剂的时候也这样子，他这个恶寒特别厉害，恶寒特别厉害当然他也是恶风了。由于他没有汗所以他加麻黄，由于他项背强加葛根，它就是这么一个方剂。

那么这一段和前面那一段回头一看就知道了，那个讲的“太阳病，项背强几几，反汗出，恶风者”，就根据这一条，这本来是葛根汤证，葛根汤证应该“项背强几几，无汗恶风，这是葛根汤证。那个呢他不是用葛根汤，他用桂枝汤加葛根，那么桂枝汤它是发热汗出恶风。那么他那个“项背强几几”呢，就“项背强几几”来讲应该是葛根汤证。可是葛根汤证呢，他是无汗恶风，所以那一条啊搁个“反”字。他这个“反”字啊就为这两个方剂的一个鉴别点，所以他这个文字啊，我们上次讲也提到了，随便一个字都不是轻易用的，他每一个字啊都是有所指的。

那么，这个葛根汤这个方剂啊，也属于一个解表方剂。你在临床应用呢，你看他特别提出恶风、恶寒的特别厉害，而且葛根这个药它是解肌，这个肌肉，尤其在这个颈背部发痉挛，这个葛根是有特效。这个肌肉痉挛就是肌不和了，肌不和原因有很多，有的由于热，这个热伤津液嘛，津液枯燥，这个组织营养失调发痉挛，也有由于这个热。那么葛根这个药呢，他是一个专务解肌（的药），它治那个肌肉痉挛。那么冲整个这个方剂啊，它（肌不和）是由于停湿停水的关系，这个湿也能够使肌肉发痉挛。因为他用的是麻黄汤，这个麻黄就能够使之发汗驱水气，那么配合葛根呢，他又能够解肌，所以这个“项背强几

几”啊他是可以好的，他是从这个方剂讲。

在《金匱要略》有一种痉病，痉病就是这个项背强达到高度了，不光是项背强了，全身都往后使劲了，这个拘急的相当厉害了，那个就叫做痉。这个痉病里头也有用葛根汤的机会，他得现太阳病，因为这个方剂是太阳病的一个发汗剂。那么这个方剂最常用了，我们在临床上啊无论是感冒啊或者流感啊，没有汗这个人恶寒特别厉害。那个项背强啊，有的他就不明显，有的非常明显，无论明显不明显，要是无汗特别恶寒，有考虑用葛根汤的机会。那么这个方剂呢，就很清楚了，刚才我讲了，它是桂枝汤的基础上加入葛根麻黄，我们上面那个桂枝加葛根汤没有麻黄，那个是有汗出，这个是没有汗。

李冠杰：这在《康平本》里边也是一个顶格排版的条文。

下边我们解读一下：

在这一条里边这个“太阳病”就是指的太阳病提纲里边所提到的这些太阳病的基本特征，“脉浮头项强痛而恶寒”这一类的阳性表证的基本特征。也就是说，他把太阳病放到这个地方，除了后边的症状以外，凡属于太阳病的症状的范畴的，都和后边的症状重叠在一起，都属于这个方剂的治疗范畴，就这么一个意思。

下边，“项背强几几”，“项背强几几”呢，我们在学习桂枝加葛根汤的时候已经解释过了，那么咱们这呢就不细说了。

“无汗恶风”，这个“无汗恶风”，这是两个症状。那么这是这个方证里的一个典型的症状。除了上边的项背强几几之外，这里又提出了一个具有代表性的典型症状。但是这个无汗也好，是恶风也好在太阳病里边都有。那么为什么单纯把太阳病里边的这两个症状列在这个地方？他有他自己的用意的啊，咱们分析一下是不是这个样子。

首先，无汗，那么这个无汗就明确地告诉我们，这就是一个太阳病中的表实证。那么把它强调出来干嘛呢？让你跟那个表虚证加以鉴别。这是区别于表实证最重要的一个症状。这是其一。

第二，恶风，那么这个恶风啊，它跟无汗同时并列在这个地方，我们应该怎么去理解啊？他实际上是提醒人们，你别忘了他跟桂枝加葛根汤表现非常相似，但是不同的就是他无汗。那么恶风呢，他把恶风放到这儿，你马上就能联想到表虚证经常用到恶风这个症状。但是实际上，我们从临床当中啊，葛根汤证，他实际上应该是恶寒特别明显。那么这个地方呢又特别放上了一个恶风，一个是提醒人们注意和桂枝加葛根汤鉴别；再一个就是提醒我们，这个跟麻黄汤证的那个表实证也有所不同。因为他这个方剂里边包括一个完整的桂枝汤。如果这么理解的话，比较全面一些。但是你不管怎么说，反正是这个“恶风”啊，如果具体到葛根汤证来说，它不如“恶寒”更确切。因为临床当中也是这样子，就是说葛根汤证的这个恶寒是比较明显的。所以说在临床当中有时候容易把葛根汤证和大青龙汤证混淆了。因为这两个方证啊，都有表实证，而且呢又都恶寒得特别厉害，比如说像葛根汤啊，或多或少的可能还会有一点点里热，虽然说没有大青龙汤那么重。但是这两个方子，像胡希恕说的，你要如果说用错了，不会出现什么大的问题，当时也见效，但是呢病往往会反复。

那么这个方剂呢，它实际上啊，从病理上我们也能看出来，这就是一个太阳病，那么或者我们这么说啊，前边因为我们学了桂枝加葛根汤证，那么它就是一个桂枝加葛根汤证，但不是表虚证，啊，没有汗出，它是一个表实证。所以说又在桂枝加葛根汤的基础上加上了麻黄。

那么下边啊我们也把这一条做个小结：

在太阳病中，有一种以表实证为基础的疾病，在表现为太阳病的基本特征的同时，又以“项背强几几”、“无汗恶风”为典型症状反应的这种疾病，为葛根汤主治之证。

那么下面呢我们也简单地看看方子。因为这个方子啊，我们理解这个方子呢，就比较简单了。这些药物里边大概除了麻黄我们还没有

说，但是大家也都知道啊。凡是在座学习的也都知道。那么这个方子呢，你可以把它理解成桂枝汤加麻黄加葛根，那么也可以把它理解成桂枝加葛根汤再加麻黄。但是呢药味的计量多少有一点点变化，桂枝和芍药跟桂枝汤比呢要稍微少一点，这个呢不会影响大的方向。那么麻黄在这个方剂当中，我们现在呢就简单地把它明确一下，它在这个方剂当中起到的作用，就是发汗解表。啊，当然它也能有那个去体表停饮的功能。

那么这个方剂，它和桂枝加葛根汤的鉴别啊，就是一个表虚和表实的问题，就这么简单。不是说里边会包括多少、多么复杂的多少项啊，非常接近。

那么下边呢，我们也搜集了一些临床统计的资料，借着这个机会呢，深究一下在临床实践当中我们能从这些统计资料当中得到一些什么启示。

关于葛根汤的临床统计资料呢，统计到了 163 例葛根汤证的医案。那么在这 163 例里边，在症状表现上，大致是这个样子：项背僵急(也就是项背强几几了)有 90 例，发热的 55 例，恶寒的 54 例，头疼的 40 例，无汗的 36 例，身痛的 21 例，下利的 17 例，呕吐的 16 例，鼻塞的 16 例。那么另外呢，还有其他的一些症状，但是呢出现的次数都在 8 次以下。所以说呢按统计学的意义上说它失去了典型意义。但是啊，通过下面的讨论我们会发现，那些症状也是非常重要的。但是呢，好多你去借鉴现代科学技术方面的一些现成的规矩，你把它拿过来以后有些不太适应。咱比如说啊，像葛根汤，它统计了这么多的医案，然后呢又把这些医案的这些个数据啊，我们在以后的学习当中，可能我不会跟大家说这么详细。咱们这个地方讲这么详细呢，是让大家有这么一个初步的认识。就说以前的时候，学经方也好，学中医也好，很少有人去侧重于分析这些资料。但是这个临床统计资料呢，你要是细究的话常常会带有某些问题。你看这一个啊，

大家发现刚才我说了啊，我把这些症状读了一下，大家发现有什么问题吗？这个葛根汤，它还治那个刚痉。就说它治那些，就我们说一个具体的病吧，它治破伤风，破伤风就有可能出现抽搐。那么为什么这些统计资料里边没有啊？对于认为失去了典型意义的那些出现次数比较少的症状里边会不会有？绝对会有，很可能就在那儿。所以说呢咱们中医这些东西是在临床来的，它有一个人有这样的反应，它能用这个方子治了，也说明这个这种症状反应跟这个方剂有一定的内在联系。啊，所以说呢这个资料恐怕是不够全面。

通过这些症状啊，我们能还能看出些什么？这个条文虽然非常简洁，但是它确实非常得科学，而且非常得周密。啊，该说的该有的都有了，该说的几乎都说到了。你比如说这个刚痉，它这个其他的地方说了，所以说这个地方就没有了。啊，那么你再看看条文多么简单哪。条文真正直接论述症状的，一个是“项背强几几”，再一个就是“无汗恶风”，啊，就这么一点症状。大家再看看刚才我们统计的一些症状里边，项背强几几有了，绝对是名列第一的一个症状；那么恶寒也有，无汗也有，你看恶寒统计是 54，那么无汗呢是 36，这都是典型症状。大家再看如果把这三个症状挑出去，剩的是什么呢？就是太阳表证的一些基本症状，你像发热呀，头疼啊，身疼啊，都是太阳病嘛，包括鼻塞。这不都是阳性表证么？所以说它的条文前边冠以“太阳病”，意义就在这个地方。里边已经包含了很多症状，恐怕我们这统计资料也不是说所有的表证都统计到了。另外，医案有时候记录也不一定是很全的。

那么，我们从这个角度来看，你看这个条文，写得是相当好了。另外，还有像“下利、呕吐”，下边的条文里边有啊。下一条就是一个关于下利的问题，呕吐的问题我们后边还会具体情况具体分析。

舌质：淡舌是 20 例，淡红舌是 6 例，另外还有绛红、红舌、微红、暗红、暗淡。但是有舌质记录的医案一共有 33 例，所以说这个

淡舌这 20 例占的比例就相当大了，加上淡红舌，占的比例就更大了，其他的都不是典型的。

舌苔：薄白的 30 例、白苔 10 例、薄黄 7 例，白腻 6 例、白滑 1 例、厚白 1 例、黄腻 1 例、厚苔 1 例，舌苔有记录的一共 57 例。

脉象：在这 163 例当中，有 72 例有脉象的记录。那么，这个脉象呢，浮紧脉 23 例、浮数脉 13 例，浮弦脉 6 例、沉紧脉 5 例。

事实上，我们读这些东西，大家听完了，会有这样一个感觉：像这些东西只能给你一个大致方向，但是哪一个也不是确定的。你比如说舌质，这个舌质跟症状不一样，这是指一个具体的部位，但是舌质变化，当然像淡舌啊、淡红舌就比较多一些，但是也有表现为红舌的、暗红的。

所以说，我们通过这个再来回顾一下经方的这个书籍，你会发现，之所以他没有给每一个方证都配上舌象、舌苔和脉象，除了一些典型的，像脉促、脉弦之类的，除了一些典型的脉给你强调一下，或者一些你仅仅看方剂，你会想不到它会有这种脉的那种。也就是说，意外的脉他会给你强调一下，其他的，他都不怎么给你强调。为什么？因为不管是舌质也好、舌苔也好、脉象也好，都没有足够的稳定性。你要如果说给每一个方剂都配上一个固定的脉象，势必会造成误导。

但是呢，我就发现过大概是有一个台湾人就写过一本书，他就做过这个工作，把《伤寒论》的每一条都给配上一个固定的脉象，这种做法是机械的做法。要如果说进一步地再去深究的话，比如说像现在有的专门搞舌诊的人，会把舌分成多少部位，哪个地方出现什么样的情况它会候什么病。大家从临床统计资料看看，有那种趋势吗？根本就没有的。有的是强调脉诊的，也是这样，搞什么微观脉诊，仅凭脉就可以确定方剂了。这些都是不客观的。

那么，下边是有葛根汤治愈记录的现代病。我们看看这些现代病，从中也能得到一些启示。这些病里边，葛根汤的治疗范围也是挺宽的。

我这个资料不仅仅是上边的 163 例了，而且它是一个从好几个渠道，把它汇集起来的。这些疾病，我就简单地读一下，后边还会做相应的分析。

颈椎病、破伤风、流感、感冒综合征、脑炎后遗症、脑血管意外后遗症、面神经麻痹、面肌痉挛、结肠炎、支气管炎、肺炎初起、猩红热、中耳炎、副鼻窦炎、慢性牙痛、三叉神经痛、肩背痛、风湿病、荨麻疹、夜尿症、高血压、乳汁不足、皮肤瘙痒、重症肌无力、过敏性鼻炎、肩凝症、骨质增生、软组织损伤、腰扭伤、踝关节扭伤、腰肌劳损、纤维肌痛症、紧张性头痛、痢疾、肠炎、胃肠型感冒、小儿秋季腹泻、麦粒肿、眼睑脓肿、重听、口鼻燥热、失音、内耳眩晕。大家看，跟葛根汤有关的这些现代疾病也是名目繁多。

但是我们讨论过其他的方剂，从这些方剂大致的列举的这些现代病里边，你也会有这种感觉，尽管说现代病和方剂之间没有稳定的对应关系，但是它毕竟有一个方向性。你像葛根汤里边涉及到五脏六腑的相对地说少，跟柴胡剂比的话，涉及里证和半表半里证的相对的少，不是说一点没有，但是比较少。

那么，尽管病这么多，但是从病理分析的角度上，我们不能离开这么一个原则，那就是说，所有的这些现代病，之所以都有用葛根汤治愈的记录，是因为什么？因为凡是这一类的疾病，就表现为葛根汤证的各种疾病，它都是在人体处于阳性表实证，并且具体地表现为葛根汤证。葛根汤证就是“项背强几几，无汗恶风”，都是在这样的病理状态下，处于最薄弱环节的脏腑或者是器官或者是组织发生病变，才发生了疾病。人体病理的基础是葛根汤证，是阳性表实证里边具体的是葛根汤证，这一点非常重要。你只有了解了病理以后，所有的方剂你都了解了病理，你再去辨别它们，你就会觉得比较容易。

我们刚才罗列了很多的数据，也学习了条文，那么我们应该从这些数据 and 条文当中体悟到些什么？需要延伸的，我们就做一个延伸。

这个葛根汤证里边还有一个就是叫“欲作刚痉”，就在痉湿喝里边也有用到葛根汤的那个条文。虽然说作为痉病跟我们上边讨论的病似乎，你看这古人他分的时候也都把它分成不同类型的病吗？而且表现呢也相差挺远。你比如说像我们说的一般的颈椎病，和那个痉病抽的都是背弓反张的，但是那种程度要差很远了，但是这里边他们都能用葛根汤治愈。说明什么？说明尽管表现差得这么远，但是他们在病理基础上是一样的，是在相同的病理状态下所发的不同的病，这一点是我们应该理解的。

另外一个就是在现代病里边有一个大家可能都听到了，有一个破伤风。这个破伤风呢，现代医学已经研究证明破伤风是感染了外界的破伤风菌以后，而发生的一种疾病。但是这个病它的表现呢是痉病，它有可能是一种葛根汤证，那么它要如果说表现为葛根汤证，就可以用葛根汤来治愈。但是这里边我们就不能不证实另一个问题，我们也不能把所有的目光全部都盯在人体上，有时候当外界的致病因素过强，在这种情况下或者说这个外界治病因素有机会，有捷径可以比较轻松地侵入人体的时候，在这种情况下，人体也会发病。但是呢就是说尽管疾病的性质说起来都完全不同，这个疾病特别是病因完全是由外界的因素造成的，但是在治疗上还是用葛根汤来治疗。

那么这里我们如果说深入地去分析的话，你就能发现中医治病的机理是什么？葛根汤哪一味药可以灭破伤风菌吗？根本就不能，没有哪一味药有这功能。但是它能增强人体这一方面的抗病能力。人体受了感染以后，它所表现出来的症状恰恰就是葛根汤的适应证，那么就说明人体感染了这种病毒以后，就出现了这个环节。那么是哪个环节弱了？我们后边再说。它就是出现了恰恰是葛根汤可以强化的这些环节，特别薄弱而发病，葛根汤就可以把这些环节强化起来，让它恢复以前的常态，就把疾病给限制到它不足以危害人体的那种程度，病也就好了。实际上中医治病就是这么一个机理。

太阳与阳明合病者、必自下利、葛根汤主之、（32）

胡希恕：葛根汤的应用不止是（31条）这么一个狭窄的问题，（这一条）就把它的面扩展了。他这个“必自下利”是个倒装句，他本来应该这个样子来看：“太阳与阳明合病，必自下利者，葛根汤主之”。这个太阳阳明合病不一定下利，如果他下利的话，可以用葛根汤主之。而且这种下利不是因为吃药得的，他是自下利。

那么怎么叫做阳明合病呢？它是同时发作的太阳病，而又有下利，下利属于里呀，这个里就是胃肠之里呀。那么胃肠之里，阳性证就是阳明病，阴性证就是太阴病。那么这个他用葛根汤了，他是一种阳性证。他所以叫作太阳与阳明合病，就是这个里阳证与这个表阳证同时发作。那么，在这个书里头他有两个合病与并病的分析。就是表病与里病同时发作，这叫作合病。如果先有表，由表传里，表没罢，里病也生了，这叫作并病，就是前一个病并到后一个病而发病，那就是并病。同时发作的那就是合病，这个是同时发作，就是说他既有表证又有下利的里证，所以他叫作太阳阳明合病。那么这种合病也是变化多端呀，如果自下利，这个用葛根汤主之。这个大家要注意，我们在临床上这是常遭遇。这个下利是一个病，这个下利以太阳里反应出来了，说明这个病有从表解的机会啊。（袁洪雷：太阳阳明合病先治表后治里，表解而下利不止的继续治阳明病；太阳太阴合病先温里后解表。我觉得这一段是为了告诉大家表里合病时的治疗顺序而不是为了强调葛根汤治疗下利的情况。）

所以中医讲辨证呀，不是我们说用葛根汤就治下利，我们不要这样看，他是下利而现表证的话，如果无汗，可以用葛根汤。他这个病呀，我们头前讲太阳病，这个病，这种机制，在生理上抗御疾病的机制大致从表解。欲汗而不得汗，所以才发生太阳病，古人管他叫合病，

其实就是表证。为什么用葛根汤呢？葛根这个药呀，我们方才讲一面，有解肌的作用，同时它有治下利的作用。那么当然是，你用其它的发汗剂就是不如葛根了，因为葛根同时有作用于下利，这个病在临床上很常见的。以发汗的法子治下利，用近代医学解释它解释不了，西医认为用发汗治下利很奇怪。他也不是随使用，要下利而有表证，要现无汗的话，大概葛根汤。要是出汗呢？大概是用桂枝加葛根汤了，我们后头有，所谓“太阴病脉浮者可以发汗，宜桂枝汤”，跟这个可以同时互参，我们讲到那时再说吧，现在不要说的太多了。那么这一段呀，主要讲的是这个下利而现太阳病的话，宜发汗为主治，用葛根汤，古人管他叫作太阳阳明合病。这个“必自下利”呀，不要这样来理解，说太阳阳明合病一律得下利，这是不对的。你看 33 条，他自己就说了。

李冠杰：这个条文在《康平本》里也是一个顶格排版的条文。

下面我们解读一下：

“太阳与阳明合病”，这里出现了一个概念“合病”。合病、并病这都是经方理论里面的一个特殊的概念。两种不同类型的疾病同时发作，就为“合病”；有先有后的二种类型的疾病，比如太阳病先发作，后来又出现了少阳病，这就是一个“太阳少阳并病”，并在一块了。实际上从它这些概念来讲对于治疗没有任何影响，并病也好合病也罢，表现为什么方证，就用什么方子来治，一个方子治不了就合方。他是为了一个是论述的方便，再一个就是揭示给读者，疾病发展变化的一个规律，这是一个合病的问题。

“太阳与阳明合病”中的“太阳病”，在这个地方是单指阳性表实证里的葛根汤证，不包括表虚证。如果有表虚证的话，那是桂枝加葛根汤证的问题。这儿“与阳明合病”的“阳明病”，后边有专门的阳明病篇，来专门的论述阳明病。但是这个地方用了阳明病，实际上它是有所指，它指的是下利一证。因为这儿出现了一个特殊的症状，

下利，但是这个症状是一个里证，所以这个地方特别说了一个阳明，就是指的下利说的。再去看后头方剂，整体读原文，这个“阳明病”的重点不是来界定这个下利就是阳明下利，后边咱们再具体的看。

“必自下利”，应该理解成如果出现下利，“必”字在这里把它理解成如果。大家可能会觉得“必”跟如果之间似乎有点矛盾，但是从前后条文对照和整个的方剂，从各个因素来看，这个“必”字绝对不会是必须或必然的意思，因为下一条，又出了一个“不下利”，在同一个方证里。而且在临床当中，葛根汤证不出现下利的情况有得是。刚才的统计资料里边也有了，163例里边纪录有下利的只有十几例嘛，不下利的有得是。所以说这个地方不能这么去理解，而且经方里好多“必”字都应该这么理解，不能理解成必然会的意思。

这一条有比较特殊的意义。

第一个就是告诉读者，如果葛根汤证出现下利的话，不要再以里证论治。明确地告诉你，这是一个里证，之所以说是一个阳明病我们后边还会说，它也有所指。为什么它不说太阴病啊？因为这是一个热性的病。它用了一个阳明病，非常含蓄。它的真实意思是要说，在葛根汤证的情况下出现的下利，不用把它辨作里证，葛根汤就可以治了，这是一层意思。

另一个，它来界定疾病的性质。其实这也是一个临床规律，和葛根汤证同时出现的这种下利，常常都是热性下利，它给你定一个性。这个阳明病在这儿就起这个作用。

第三个，它给总结一个规律性的东西，葛根汤证容易同时发生热性下利。在临床当中，凡是患葛根汤证，如果同时又出现了像理中汤证的那种虚证，里虚寒的那种下利的可能性就不大，恐怕这样的医案我们很少能见到。当然如果确确实实是你辨证正确的话，你也得那么治。但是它出现的机率非常低，因为如果真正的里虚寒证的那种程度，恐怕出现葛根证的机会就少了。

如果再展的宽一点，这个下利跟表证同时出现下利的，不仅仅是葛根汤证，桂枝汤证它也可以见到下利，但是那个下利就略微偏于寒了，主要是虚，里虚有略微的偏于寒。

还有一个更明显的就是桂枝人参汤证的下利，桂枝人参汤证就是里虚寒为主了，表证为辅，表证是个次要的，里虚寒很重，到了完谷不化那种程度。所以说要是这样看葛根汤，跟葛根汤同时出现的下利大多都有热性下利。

给本条做一个小结：如果单纯的葛根汤证同时出现下利的话，多属于热性下利，也是葛根汤主治之证。不要误辨为其他类型疾病而妄加治疗。

用我们今天的话把它说出来，这个条文就比较明确了，不用拐那么多的弯。

大阳与阳明合病、不下利、但呕者、葛根加半夏汤主之、

(33)

葛根四两 麻黄三两去节 甘草二两炙 芍药二两 桂枝二两去皮 生姜二两切 半夏半升洗 大枣十二枚擘

右八味、以水一斗、先煮麻黄葛根、减二升、去白沫、内诸药、煮取三升、去滓温服一升、覆取微似汗、

胡希恕：他说个不下利，所以上面那个“必自下利”，那就是不对头了，不是吗？他是个倒装句，是“太阳与阳明合病必自下利者”，这才能用葛根汤。所以下一段他这个就又说了，这个葛根汤呀他还可以加味，也是表里同时有病呀，但是他不是下利，而是“但呕”，呕就是呕吐。那么这个用葛根汤呢，就得加半夏，半夏治呕。当然这个呕也是以表证出现，以太阳病出现，也就是和我们解释上一段一个意

思，就是这个病呀打算从表解。

古人把这个呕也看作里边，属阳明，所以也说是太阳阳明合病。那么我们通过临床的实践证明，这个葛根汤加半夏治这个太阳阳明合病不下利但呕，如果也下利也呕怎么办呢？也用这个，也行的。因为这个葛根汤呀，就治下利而现太阳，同时如果有呕，加半夏就行了，根据这个加减的规律，也可以这么样子理解，事实呢也确实是这样的。

那么另一个问题呢，我们也应该注意，这个葛根汤不是治下利嘛，不过葛根这个药呀，他这个方剂是用它为主呀，量也大。这个葛根呀是一个寒性的，它是甘寒，所以在《神农本草经》上说它：“治身大热，消渴”，它起这个作用的。这个药于胃不这么合适，我们平时用葛根汤的时候，那么这个人胃不好，你也要加半夏，这个半夏能够去水，这个胃虚爱停水的，同时它是与甘药一起发挥健胃作用，所以我们用葛根汤的时候就要这一点。那么这个人就是不呕，他这个胃不好，食欲不好，也要加半夏，这个是我们临床实际应用的时候要知道的这种问题。

那么这个葛根汤加半夏的煎服法跟上面的葛根汤是一样，我们凡是有麻黄要煎的话，都是要先煮麻黄，葛根这个药同样先煮的，因为葛根这个药它不好在水里溶解的，所以与麻黄一起煎，然后把上头的沫撇出去，然后再加旁的药，凡是用麻黄都是要注意这一点。这个方剂就不用细解释了，知道葛根汤了，这个葛根加半夏是个加味的办法了，半夏治呕咱们都知道，所以葛根加半夏呢，就是这个葛根汤证而呕者，我们这个样子来领会这个方剂的应用就可以了。

李冠杰：这个条文是顶格排版的条文。

下边我们解读一下：

这里的“太阳与阳明合病”，它的意思和意义跟上边那条都一样，我们就不去细推敲了。

这个“不下利，但呕者”，我们应该怎么去看它？“不下利”，

第 32 条里边的“必自下利”，那个绝对不是一个必见证。葛根汤虽然加了半夏，但还是葛根汤为基础的。这儿明确地说“不下利”嘛。

“但呕”，强调又有一个呕吐的症状“但呕”。从字面的意思看，就是说不下利，只是呕吐。可是在实际临床当中，还会碰到既有下利也有呕吐的，实际上也是依这一条。前边说了太阳与阳明合病，那么，与阳明合病指的就是这个呕。

这个呕，我们从病理上看，就是胃功能低下，胃中停饮发生的呕。从哪儿看出来？从加的药里边就能看出来。

但是这里边可就有一个问题，大家可能会想，加半夏是一个温性的药，是不是因为里虚寒而呕啊？这个寒绝对不重。我自己体会这也不是因为胃寒而呕，主要的问题是停饮。就是胃虚弱，吸收水分的能力差，喝进去的水，一些流食停在胃中不得消化，就要吐出来，是这么一个过程。为什么呢？因为加了半夏的量有限，这个是其一。

再一个，半夏偏温的性质如果跟干姜、吴茱萸、附子相比的话，没有那么热，只是偏温。但是葛根用量一个是比较大，再一个就是葛根偏寒得比较厉害。如果说胃中因虚寒而呕的话，光加半夏也不行的。

再说，只要有葛根证，里边偏于寒的可能性就比较小，这也是临床其中的一个规律。

这个条文论述的是什么呢？论述的是这个人平素就胃虚停饮的，他患了葛根汤证，就容易加重胃中停饮的这种状态。

我们做一个小结：平素胃功能不佳的人，患了葛根汤证后，因里虚停饮加重而发呕吐症状，此为葛根加半夏汤主治之证。

半夏是一个温性的祛水的药。重点是去胃中水饮，有明显的止呕的作用。

我们再延伸一下，治呕的药不仅仅是半夏这一味，吴茱萸也是一个温性药，而且也治因胃虚胃中停饮发生的呕吐；生姜也有类似的功能，干姜也有这样功能。为什么这个方剂里边却不用这些温性的药

啊？我们从两方面说：

一方面，有可能伴随着葛根汤证出现的这种呕吐，没有寒到必须用这种药的程度，这是其一。

另一种可能性，半夏有其他的药物代替不了的功能。那些药放在葛根汤里边，疗效就没有半夏好。

对这一条我们也做一个简单的延伸，我们意图把所有应该想到的问题也都能想到。

一个问题，这是胡希恕提到的一些问题啊，如果是葛根汤证，同时又呕吐又下利怎么办呢？其实，很简单，既有呕吐也有下利的话，同样可以用葛根加半夏汤来治。好像这里就跟条文的论述多少有一点出入。所以我们理解条文呢，这个地方“不下利，但呕”，是来强调呕吐。但是，实际临床当中啊，也确实有既呕吐又下利的这种情况。

另外一个啊，就是没有明显的呕吐或者下利这种反应，但是，这个人平素胃功能就比较虚弱，加半夏也是比较好的。

另外，用葛根的时候，一定要注意这个人的胃功能怎么样。这个人是不是胃平素就比较弱？再一个是不是有胃寒的这种情况？如果有的话，用葛根一定要小心。这个在我自己身上就有体会啊，就是我那个颈椎病，快要好的时候，比较重，挺难受，我也有时候有点汗出，我就吃一次桂枝加葛根汤，也就当试一试药。吃了以后，肚子里那个凉啊，凉得有点难受。这个药还是比较寒的，是偏于寒的。

下边是葛根加半夏汤的症状的统计。上一条葛根汤症状统计里边也有呕吐。从其他的药的论述来看啊，葛根也有治呕的这么一个功能。葛根汤如果能治呕吐的话，为什么还要加半夏呢？这里边恐怕还有一个寒热虚实的问题。《伤寒论》里边要求加半夏的必定是胃比较虚，热又不是说特别重的哪一种。这里边还不能排除另外一种因素，咱们统计这个医案呢，纯用经方一点不加减的也不是很多，这里头不排除把这个葛根加半夏汤就统计进去了。

症状：发热恶寒、头痛、无汗、身痛、项背强急、面赤、额头作痛、呕吐或者说吐清水、下利、腹痛。

舌质：淡舌为主。

舌苔：薄白根部有点厚。

脉象：浮细、浮濡、紧、浮紧、沉紧。

现代疾病呢：胃肠型感冒、慢性胃炎、十二指肠溃疡、慢性非特异性溃疡性结肠炎、胆囊炎等。

另外呢我从一本书上发现了一句话，葛根加半夏汤对慢性胃炎，有反射性后背疼痛并呕者疗效尤佳。这肯定是来自于临床经验。这是一个典型的医案。

如果你遇到这一类的情况，有比较典型的葛根汤证的疾病反应，同时又有反射性疼痛、胃中不舒服，又呕，他没呕也没关系，你可以用葛根加半夏汤。应该是疗效很确切，因为葛根作用于项背部嘛。

下面我们从方剂、方证、现代疾病方面来看一看葛根这一味药的作用。我们看看能从这里边能看出些什么来？

首先一个问题，经方里边用到葛根这味药的方剂，一共就这么六个方子：葛根汤、桂枝加葛根汤、葛根加半夏汤、葛根芩连汤、奔豚汤、竹叶汤。所有这些方子里边基本上都涉及到了表证。

我们换一个更高的角度，对于葛根的药性，从几个方面看一看：

一个是《神农本草经》论述的，葛根一名鸡齐根，味甘平，无毒，治消渴身大热，呕吐，诸痹，起阴气，解诸毒，葛谷，治下利，十岁已上，生川谷。

《药典》是这样论述的：甘辛凉、解肌退热、生津、透疹升阳止泻，用于外感发热头痛、项强、口渴、消渴、麻疹不适、热利、泄泻、高血压、颈椎强痛。

下边呢，再看看胡希恕有关葛根的一些论述。这是胡希恕讲《伤寒论》和《金匱要略》讲座里边，我在学习的过程中摘出来了。葛根

可治疗因湿热而造成的肌肉组织痉挛拘急，特别有效于项背部，大量用亦可解表，这是一层意思；另外一层呢，葛根可治疗以葛根证为基础的下利。第三个呢，葛根对胃功能有一定的不利影响。这是胡希恕从大量的临床实践当中总结出来的。特别是葛根对胃功能有一定的影响，这在其他的资料里边是看不到的。

但是，通过上边这些比较权威的对葛根的论述啊，我们感觉还是不特别的明确。那么，再通过我们现在掌握的资料，我们试着再去做一个分析：

首先从现代疾病的角度，通过刚才的统计资料，我们可以把葛根汤证大概分成这么几种类型：

一类呢是表证：感冒这一类的，还有肢体方面的一些疾病，还有面部神经麻痹，这也是属于表证嘛。凡是表虚证的，就是桂枝加葛根汤证；表实证的，就是葛根汤证；那么阴性的啊，有可能会用到竹叶汤；那个热严重的，就是葛根芩连汤证了。这一类的病呢，病变部位大都集中在体表，我们就简单地归成表证这一类，这是一类疾病。

再一个呢，就是里证。肠道里边的疾病，呕吐呀，或者下利啊，属于里证。

第三类呢，就是葛根汤证中葛根的本证，也就是葛根正治的一些病。颈椎病，腰肌劳损，项背强几几这一类的疾病。那么，这一类的疾病呢，离了葛根治不了。不管用什么方剂，跟葛根关系都比较大。

那么这儿呢，我们就能看出：葛根就有作用于这些组织的这些特殊的疾病。比如颈椎病，按中医说呢，是血脉不通；按照西医说呢，是压迫神经。还有腰肌劳损，面部神经麻痹这一类的病。这一类的病，实际上都跟人的神经系统，就是运动神经系统关系比较密切。那么葛根是不是就对运动神经失养的这种情况有作用呢？

我们下边再看看，葛根要如果跟别的药再进行一下比较的话，我们也能发现一些有意义的，关于药性方面的一些启示：

首先说，葛根所治的这些里证啊，呕吐或者下利，跟这些症状关系比较大的药有吴茱萸、生姜、干姜，白头翁、黄连、黄芩。吴茱萸、生姜、干姜，都是针对的是寒性的；白头翁、黄连、黄芩，是针对热性。但是，都对下利有作用。这么一比较，你就会发现：葛根汤所治的下利，用其他的药肯定是治不了的。那么它治的下利是怎么来的？是不是也跟肠胃的运动神经的失养有关？

再一个，葛根大量用可以解表，还有一个解表的功能。但是葛根这个解表的功能，如果跟桂枝，麻黄，防风，荆芥这一类的比较一下，它没有明显的发汗的作用。而且，葛根所治的那些关于肌表方面的其他的疾病，像神经麻痹之类的，其他的药治不了。桂枝汤，麻黄汤，包括防风，甚至黄芪，要去治这一类的病，它们治不了。要治得了的话，就没必要用葛根了。这样一比较呢，葛根所对的恰恰是那些药治不了的一种状态。这种状态是不是跟那个神经系统有关？

另外呢，还有一个药，可以跟葛根比较一下，尽管它们作用的对象不太一样，但是呢有一比，那就是芍药。芍药治疗什么？治疗肌肉组织因为失养而出现痉挛，疼痛。医院里边常说的缺钙，不管多大年龄的吧，只要一抽筋了，就会说：你这缺钙了。如果去化验化验指标的话，真的缺钙了。他为什么缺钙呀？恰恰就是因为合成这种营养的能力不足。那么谁能解决合成这种营养能力呀？就是芍药，芍药就能起到这个作用。

葛根是不是在这方面跟芍药有异曲同工之妙啊？芍药主要作用于肌肉组织；那么葛根呢，主要作用于运动神经方面的。

最后呢，按照我自己的理解，葛根能改善人体某些运动神经因失养而出现的以拘急为典型症状反应的病理状态。至于具体的机理，恐怕想揭开的话，这还是一个很遥远的问题。

再一个，从葛根汤所治疗疾病里边，有一个是高血压。葛根汤可以治疗高血压。我们从这儿不妨去揣摩一下，从这个角度再去审视一

下高血压病。血压升高本身就是人体对已经发生的病态的整体进行自我调节的一个必然反应。或者某个组织、或者某些器官血液供应不足。在这种情况下，人体就反馈回一个信号，通过大脑中枢调理心脏，让心脏打的血压高一点。血压高了以后，就会出现血液供应过盛了，就攻的人头痛，或者出现一大堆的不适。这不就是高血压的症状嘛。这只是高血压的一种。还有，高血压的人有停饮。停饮不就是或者肌肉组织里边，或者脏腑里边，应该走的废水走不了，废水在那个地方就影响新的体液的供应，也就是局部缺乏营养。缺乏营养的时候，人体就要增加循环系统的循环的力度，也就是提高血压，改善这种能量供应不足的情况。

在这种状态下，降血压是个不太好的办法，是没有办法的办法。现代医学就认识到这一层，就是这么一种治疗的背景。

葛根汤证也是某些组织失养，失养了以后，用其他方式调节不了，可能就会用提高血压的办法来代偿，如果把葛根汤证的体质改变了，把那些障碍去掉了，这个血压就会正常了。当然这是高血压的一种。有因为水的，有因为瘀血的，还有因为里热的，也有因为里寒的。这个都没关系，因为什么，你去辨证就行了。

所以从这个意义上说，尽管两三千年以前的古人没有高血压这个概念，但是却找到了治疗人体这种病理状态的办法。经方是一下就找到了治病的最佳途径。

这是从高血压这个病我们想到了这么多。

另外，还有一个挺有意思的事。日本人做过实验，凡是服了葛根汤的人，在 5-20 分钟这一段时间里边，后颈部和背部的皮肤表面的温度在逐渐升高，直到 30 分钟以后，才开始有一点点下降的趋势。但是，其他的解表药桂枝汤、麻黄汤没有这个功能。这就说明我们从临床实践中认识到葛根汤可以治疗颈项背部的一些拘挛的症状，跟这就能统一起来了。至于机理是什么？要揭开那还早着呢。

那么这儿呢，我再跟大家说一个病。说起来已经是两三年前的事儿了。

这个人哪，在我上班的路上，他自己开了一个店，他就在我路过他门口的时候，让我给他看看。那么第一次呢，他的主诉就是因为着凉了，感觉到颈椎强急，有点痛，腰痛，四肢关节冷痛，身无力，脉细弱偏迟。我给他的方子呢，给了他葛根汤，葛根加了点量，又加了白术、附子。当时是10剂，一天服两剂。三天后再碰见他，他说明显得好多了，就这一次药就好了。第二次是两个月后，他说我颈椎病又犯了。当时的脉象呢是弦细，而且他还有往来寒热，口苦，有些小柴胡汤证。我就给他小柴胡汤合上葛根汤。这个吃了以后，大概就给了他三天到五天的药吧，病就好了。这个医案呢，就说这个人有两次颈椎不好，因为他出汗不太多，用的是葛根汤，但是都合着别的方子。因为他有别的证，所以就得合别的方子。

大阳病、桂枝证、医反下之、利遂不止、脉促者·表不解也·喘而汗出者、葛根黄连黄芩汤主之、（34）

葛根半斤 甘草二两炙 黄芩三两 黄连三两

右四味、以水八升、先煮葛根、减二升、内诸药、煮取二升去滓、分温再服、

胡希恕：这个太阳病呀，本来是桂枝证，你看这个书，它提出个桂枝证，桂枝证是什么呢？桂枝汤证。所以这个书里头呀，这一个方剂的应用，它有它一定的适用范围。这就是某个方剂的适应证，就叫做某方剂之证，他简言之，比如桂枝汤证就是桂枝汤的适应证。什么适应证？我们头前讲了，发热、汗出、恶风、脉缓这类病就是应该用桂枝汤。这个太阳病呀，他本来是桂枝汤证，就是发热、汗出，恶风

这类的太阳病，那么治病的这个大夫呀，他不知用桂枝汤，而反用下法，给吃泻药，这错了。一吃泻药呀，他里边本来没病，一吃泻药呀里边就虚了，那么这个外邪乘虚就进里头去了，所以就发生“利遂不止”。这个外邪呀就是热邪呀，古人管这个叫协热利。协同下药，这个热协同下药而做下利不止，这叫协热利。那么他这个是误治造成的了，由于误治不但造成协热利，利遂不止，同时呢这个表也没解，所以这个脉促。

脉促咱们讲过了，这个寸脉浮，这个《金匱要略》上有，脉浮在前，其病在表呀。这个表证的时候，关以前的脉是要浮的。所以这个促脉呀，咱们上次讲了，他又迫近于上又迫近于外，就是寸脉独浮这么一种脉。那么现在这个脉促，这证明表还没解。他误治了，本来应该用桂枝汤汗以解之，这个大夫给吃泻药，一方面引邪入里而下利不止，另一方面表也未解，所以脉现促。

“喘而汗出者”，这个表里俱热呀，这个热呀，凡是热都往上，热涌于上，所以他人要喘。这个汗出有两个问题，一个是里头热也使他出汗，根本桂枝汤证就没解，也是出汗。那么这要怎么治呢？用葛根黄芩黄连汤主之。我们方才说了，葛根这个药呀有治下利的作用，同时你大量用也解表，解表解肌嘛，那么，这个由于里边的热，所以。。。。。。（音频缺失）。这个是补胃的一个收敛药，它有治下利的作用，那么葛根配合这个黄芩黄连呢，一方面去热，一方面治利。这个黄芩黄连咱们常用啊，治下利用苦寒药只要是热利就行，像白头翁汤啊，这都是用苦寒。可是苦寒药不全治下利，栀子就不行，所以黄连、黄芩、黄柏、秦皮、白头翁这类的它都有收敛的作用，所以它能够治下利。那么栀子，大黄更不行了，那也是苦寒的药了，所以苦寒药咱们也得分析。那么这个方子，它一方面用葛根，大量用解肌解表，一方面伍以黄芩黄连来治邪热下利，那么这甘草呢，咱们常说它是调百味，其实它也起作用，它治急迫，你们看看这个症急迫不，

“下利不止，喘而汗出”，都有急迫的症状，这个病现急迫之情，这个时候都用甘草，急迫啊。所以这个方剂，表不解，里有热，下利不止，它这个有里热，是热它往上，所以它反而汗出。那么这个方剂，也很好理解，它以葛根为主药，葛根伍以甘草，它是解肌、解表；伍以黄芩、黄连而治协热下利。那么葛根也要先煮，但是不用去沫子。麻黄去沫子是因为麻黄这味药这个沫子啊，有点副作用，上面这个沫子，使人头晕，所以用麻黄的时候要去沫子。葛根这个药呢，溶解于水的时间比较久一点，所以它先煮。这个方剂在一般治痢疾的时候，要有表证不可以用葛根汤，这种下利有用葛根芩连加甘草的机会，尤其是小儿痢疾的时候用这个方子的机会挺多。这葛根用少了，它不起解表作用的。

李冠杰：这条和《宋本》比较一下，旁注里“表不解也”在《宋本》是“表未解也”，没有原则的区别。再一个就是方剂的名称，《康平本》是葛根黄连黄芩汤，《宋本》是葛根黄芩黄连汤，黄芩和黄连颠倒了一下，也没什么大的区别。但是最好把方剂名称统一一下，比如想通过软件搜索就会省好多事。这个条文在《康平本》里是顶格排版的条文。

我们下边解读一下：

这条里有了七个字的旁注，在《宋本》里把它给篡入正文了，估计是王叔和第二次整理时全部篡入正文的。旁注篡入正文后就对后世的解读、理解发生了一些影响，对这条大致有两大类的读法，读法就不一样，考虑到大多数人没有见到《康平本》的因素，其实两类读法都有道理。没道理的是把旁注篡入正文的人，对后世的解读造成了误导。

比较流行的一种观点就是把这条分成两段来解读，第一段从开始一直到“表未解也”这个地方为一段；下边的是另一段。这样解读就成了“桂枝证，医反下之，利遂不止，脉促者，表不解也”到这儿是

一段了。就是说本来是个桂枝汤证，误下了以后造成下利的症状，如果脉还表现为促脉，那是表还没有解，还得用解表剂治疗。如果用解表剂就跟后面的方剂没有关系了。解表剂就成了言外之意了，那就成了桂枝汤证，桂枝汤也治那种表虚证有下利的情况嘛！这就大相径庭了。那么葛根芩连汤治的仅是喘而汗出，就成了这么一种解读了。仔细品一品，凡是能这么解读的人还真是对原文进行了再三的推敲。但是问题出在哪儿？出在把旁注内容篡入正文，人们在细品的时候就发现从这个地方断开也可以，而且更合理，就会有那种感觉。但是看到《康平本》，任何一个人都不会再那么解读了。

另一种解读方法，就是整个条文做为一个整体来解读。就是葛根芩连汤治那种表虚证还没好，又出现了热性下利，同时表现为喘而汗出的情况。这样就比较全面一些，作者本来是这么一个意思。

从这个地方我们再延伸一下。因为有一些都是带有根本性的问题。如果仔细想想，这里面确实隐藏了一些学术方面的不良倾向，咱们就在这顺便提一下。这个旁注假设像某些专家说的，《康平本》是日本的某些学者出于某种学术上的目的，把《宋本》凭空改成了这种形式的。大家想想，什么人能在毫无依据的情况下，单独地把这一条文里的七个字列成旁注？任何人都做不了这样，因为他没有任何依据。所以我一直持这种观点：《康平本》根本就不可能是由《宋本》写成的，它只能是《宋本》的一个原始版本，这才是个真的版本。后面我们还要做解释。

“太阳病，桂枝证”它本身应该有两层意思：一层意思是明确了条文里论述的疾病类型。这个条文一开始论述的原始疾病类型是阳性表虚证，就是桂枝汤证；第二层意思，这个桂枝证在这个地方是一种病。等于说不单单地提出了一个方证的问题，而且是用它来界定疾病的不同类型。从这个地方我们能看出，经方对疾病的划分、界定跟其他任何医学都不一样。这一点大家可以去品。当然从这一条只提到一

个桂枝证。你再整体地联系六大类型的疾病，包括后来的人解读的像寒热虚实等等，把这些因素结合到一块儿，你发现经方对疾病的分类方法、界定的标准跟其他任何的医学都不一样，包括传统的中医。

“医反下之，利遂不止”。就再一次强调这个病不能用泻下的方法治疗。在当时对一些表证用泻下的方法来治疗，恐怕在社会上是比较流行的一个误治的办法。所以特别地拿出来强调，而且做专题的讨论，给一个处理的办法。“利遂不止”按原文的意思应该是吃了泻下的药以后出现下利。这是正常的，但停了药以后下利还没有消失，依然保持着下利的症状，就把它叫做“利遂不止”。这里边就隐含了一个用的什么药下利的问题？这个事很重要。如果我们面前有一个桂枝汤证的患者，你给他用大承气汤、调胃承气汤，吃了以后他可能出现热利么？大家学这一条，你时刻要记住它是一个热性下利。要是用大承气汤、小承气汤、调胃承气汤，哪一个药物也不至于导致下利不止。因为它前边有前提说这是一个桂枝汤证，桂枝汤证本身就没有明显的里热倾向，一旦有了明显的里热倾向桂枝汤就不合适了，就不是桂枝汤证了。为什么吃了泻药以后反倒是“利遂不止”呢？那是因为他用的药是巴豆剂，这在当时也是一个常用的药，巴豆剂是一个温性的泻下药，所以吃了以后造成有里热，同时这个下利也好不了。我们现在用巴豆剂的机会比较少了，大家看一看《金匱要略》在二十二篇以后附的那些方子，里边好多是用巴豆的，而且是治一些急症、重症。今天因为有现代医学，用巴豆剂救急的可能性非常小了，所以现在用得是越来越少了。但是这个药非常值得研究，这个药吃了以后上吐下泻，而且它是温性的，上吐下泻还能救一些类似休克之类的病。

“脉促者，表不解也”，这是一个旁注的内容。客观地说，这七个字就是画蛇添足，一个是这个方证并不一定准现促脉，就是寸脉独浮的脉；第二“表不解”条文里已经包含了这么一个意思，前边说的“太阳病，桂枝证”，先说明了这是一个表虚证，下完了以后，治疗

的方剂里还有解表药在，有大量的葛根啊，说明表证还没好。所以说，这个注解可有可无，如果它不篡入正文，对理解正文或多或少有一点点帮助，至少它不会形成大的妨碍。但是一旦篡入正文，你是越研究得细致就越容易被误导。

下边是“喘而汗出”，我们应该从两个方面理解。一个方面从病因上说，一是表虚证还没好，有表证常常会影响到呼吸系统，另外已经形成了比较强盛的里热，既有半表半里的热，也有里热，所以半表半里就直接影响到呼吸系统。虽然不一定每个人都会这么严重，但热盛了也很容易造成人咳喘的情况。再一方面就是“汗出”，汗出是因为有里热，要用出汗的方式来散热，另外表虚证还没有好，也会伴有汗出，这都很正常。这是该方剂的一个比较重要的症状。

单纯从字面上讲，这个条文到这儿方方面面都照顾到了。如果再深入体悟一下，我们还能从中得到一些其他的启示。比如，经方方证虽然说是经方理论的一个核心和基础，但它却是一个动态的病理反应范畴，它不是一个固定的。这一条里它说这个病有什么样的症状反应啊？有表虚证，这是误治完了以后表虚证还没有好，又出现了下利、喘而汗出。那是不是临床当中所有得这个方证的病人都要具备这些症状？那可不一定。再一个还常会伴有其他的症状，比如，有经方基础的人都知道葛根芩连汤还可以治牙疼，有这个方证的牙疼吃了还好得很快，整个经方书里压根就没提到过牙疼这一个症状。那么我们应该怎么去看待经方条文里所列的这些症状？要如果完全的按着它去套，肯定不行，它一个是不全，再一个有的条文有时甚至都忽略主证，让你自己到方子里边去揣摩。但是我们现在用经方的依据呢？条文还就是最根本的，你还得从条文里去体悟。我们应该怎么去看待经方里面条文对方证这些论述呢？咱们再看看这个条文，这个条文开头是“太阳病，桂枝证，医反下之”，就跟我们首先确定了一个基调，就说这个人以前是个阳性表虚证，然后又用了泻下的方法治疗。用泻下的方

法治疗，表证有可能解除不了，但也有可能好了，这是另一回事，咱们以后再讨论。这一条是没有解除，方剂里边有葛根嘛。如果没解，它就应该有表证的一大堆症状，比如发热、恶寒，这儿不是说了一个汗出吗？只有发热恶寒甚至有头疼可不可以呀？完全可以。但是像这个它就不再论述了，因为在太阳病桂枝证里边已经包含了。虽然说“医反下之”，是说下了以后病没好，这种症状完全可能有，有时候没有也没关系，只要是病理状态能对得上，就可以使用这个方剂。这就是活用经方的一个基础，认识不到这一步，经方就很难用的比较灵活。

再看“下利”、“喘而汗出”，好像是主要的症状都有了。“下利”是一个比较典型的症状。但是“喘而汗出”不知道谁能在临床当中遇到过这种病。我遇到过，也用了这个方子，用对了它疗效非常得快。“喘而汗出”在临床中有时候不一定是必见证，为什么特意把它写在这儿呢？实际上是在强调它，因为这个症状在方剂里边难以体悟出来，葛根芩连汤这四味药要说治喘可能就会想不到，所以作者特意把它作为一个特征性的症状放在这个地方。事实上它还有好多其他的证，在临床统计结果里边有，比如腹痛、牙痛、烦躁啊，都是出现的几率很高的，比“喘”出现的几率要高。我遇到过一个病人啊，一开始给他治的是胆囊炎，后来差不多快好的时候一直就是偏热，因为十年的胆囊炎，体质不是特别强，没有给他用去热泻下那么重的药，所以他一直偏热。后来胆囊炎差不多好了，他说这两天牙疼、肚子疼。我问大便怎么样？他说大便有点跟脓差不多。我就给他葛根芩连汤，吃了一次就好了，后来我又让他吃了一次。

实际上这个方证还有好多其他的症状，而且都比“喘而汗出”出现的几率还高，但是这儿没说。没说不等于没有。大家可能会说你不说我怎么知道有还没有啊？方剂在这儿摆着呢。所以读经方的条文，要去用这种思维方式，你得习惯古人这种条文非常得简的叙述方式。像第 62 条新加汤，就说了两个症状“发汗后身疼痛，脉沉迟者”，

事实上这个方剂就是桂枝汤的一个加减方，它完全可能有桂枝汤的所有症状，但是它都没有说，因为在方剂里应该能看出来。这儿它就用了更特殊的方式，这个“喘而汗出”，有了喘以后，你可能会认为还会有其他的药证。因为热证，肯定会有其他的热证，你可能会用错了药。这儿就特别强调，除了方剂有可能出现的症状以外，“喘”这个症状在方剂里出现的话，也是它的主治之证。它就是想强调这个，经方里这类的论述方式很多。有的方剂它真是给你列举了一个特征证，而并不是一个必见症，有的人不一定有这个症状。但它是作为一个特征证告诉你了，因为古人写作条件有限，形成了这么一种论述方式。我们今天得习惯这种论述方式。

我们把这一条做个小结：本来是太阳病中的桂枝汤证，但是因为医下之，造成下利不止，如果同时出现喘而汗出的，为葛根黄连黄芩汤主治之证。

这个方剂是一种表虚、里热、半表半里有热的一种病理状态。

这个方剂一共四味药，葛根半斤，甘草二两，黄连、黄芩各三两，葛根是一味寒性的药，有去热的作用，主要是用来解表，同时也可以治疗热性下利，所以说葛根在这儿是主药。甘草的作用比较简单，就是补里虚、缓急迫。黄连、黄芩都是寒性药，去热的力量比较强，同时又都有止下利的作用，比较对这个方证的病理状态，同时它可以解烦。我出一个题目，大家反复地去感悟黄连、黄芩、黄柏这一类药，去体悟它们跟石膏的关系，石膏也去热，咱们举的这几个药都有治下利的作用，栀子它就不治下利，也去热，石膏也去热，大家可以去临床当中反复地去验证，要反复过几个来回，然后才能分清哪类的是石膏证，哪类的是黄连黄芩证。如果分不清，用错了药，常常会觉得这个人热得这么厉害，用的方子对啊，可是吃了以后不舒服。

下边是搜集的一些临床统计资料，搜集到有记录的案例一共是155个。在症状方面有记载的：下利144例，发热124例，腹痛75

例，小便短赤 71 例，口渴 70 例，恶心呕吐 49 例，另外还有像烦躁不安、纳呆、心烦。在搜集这些资料的时候，我发现有一本书上记载了一个比较特殊的症状，这个症状临床当中很有用。就是下利胶冻、时有粘沫，这是热痢的一个很重要的特征。一般像寒性下利是下利清谷、水泻这一类的。一旦要是下利跟胶冻一样，或者是一些泡沫类的东西，多是热性下利。

舌质：有舌质记载的是 66 例，舌质红的是 54 例，舌尖边红的有 5 例，舌绛无津的是 5 例，舌红干 1 例，光滑而红舌 1 例。

舌苔：有舌苔记载的是 108 例，黄苔的 36 例，黄腻苔 27 例，薄白 15 例，腻苔 13 例，黄厚而干 8 例。

脉象：有脉象记录的是 106 例，像数脉 26 例，滑数 25 例，弦数 13 例、浮数 7 例、沉数 7 例，细数 6 例。从这个脉象里明显地看出来，王叔和加的那个旁注就不太准确了，没有一项是说所谓的促脉，也不一定不会出现那个脉象。但是从这里我们能看出王叔和有时候常常治学态度不够严谨，而且过于机械地偏重于脉象这一个症状。后边还有很多。

葛根芩连汤有治愈记录的现代疾病：阿米巴痢疾、细菌性菌痢初期、急慢性痢疾、急慢性胃炎、慢性非特异性溃疡性结肠炎、出血性肠炎、支气管肺炎、大叶性肺炎、病毒性肺炎、肺脓肿、喘息、口内炎、中风、乙型脑炎、神经衰弱、婴幼儿轮状病毒性肠炎、小儿中毒性肠炎、婴幼儿夏季腹泻、小儿麻痹症、感染性高热、膀胱炎、新生儿尿布疹、婴儿湿疹、消化不良、伤寒及副伤寒、食物中毒、牙痛、流行性结膜炎、脱肛、带下、内耳眩晕症、麻疹、肾病综合征、尿道炎、急性多发性神经根炎、并发性房性期前收缩、高血压、动脉血管硬化。

这些疾病看起来好像是有好多病，感觉到用这个方剂治起来可能是不是会勉强。因为统计资料里边，很多统计说是用这个方剂治的病，

但是好多都是在这个方剂上做了加减的医案。所以我们应该客观地看，不是说葛根芩连汤能覆盖这么多的病，那也不一定。要是单纯现葛根芩连汤证，用葛根芩连汤没问题，但是要还有别的方证，还要合上别的方剂。这是学习这条应该知道的一些内容。

下边，咱们做一点点延伸，通过学习这条应该有所感悟的在哪儿呢？有两个层面：一个层面是病因部分。太阳病桂枝证，然后医反下之，这不是一个病因嘛！这个病因部分再具体地说一说，加深一下大家的印象。第二个层面是治疗部分，这部分也有我们应该进一步体悟的。

先说病因部分。在条文里一共就是十个字“太阳病桂枝证、医反下之”。大家不要小看这一句话，它里边的用意非常得多，不是一箭双雕的问题，你得反复地去品味，古人常是这样。首先说明了这一条论述的疾病的原始状态，就是太阳病桂枝汤证态。第二个意思就进一步地声明用了什么样的误治方法，就是说这种方法是不可用的。笼统地说就是泻下的方剂对于表证是不可用，“医反下之”嘛，不应该用，这是误治。具体的条文里温性的泻下药也不能用，它可能造成那个热利。第三，它同时在里边还隐含着有什么啊？就是用温性的泻下药可能造成的其他后果。第四，它这个病因给理解方证提供了必要的病理条件，如果能从这些方面看这个病因，再参考方剂就能想象病人还应该有一些条文里没写明的症状。我们要知道其他条文的病因也都是类似的情况，它可不是单纯的病因。现在有人学经方机械到常问：条文里说的是经过泻下误治以后出现的这种情况，没有经过误治能吃这种药吗？这完全都是机械的。

治疗方面的，不管有没有条文中论述的病因，凡是符合这个方证的都可以用这个方剂来治愈，这一点很重要。只有理解到这一个层面上，你才能读出条文来，才能不被条文里有限的几个症状限制住。其实古人不是要限制你，就是想让你思考，应该想到的你得去想。

最后一个问题，我们这次学习在国内是以《康平本》为主线，同时与《宋本》的所有内容比较，这是首次。我们也是经过了反复思考的，从学这一条大家是不是想到了这一点。象这一条如此明显的问题，对比一下《宋本》和《康平本》，仅仅就是这一条如果作对比，没有哪一个人会做这样的结论：《康平本》是经过《宋本》改写而成的，一字不差只是把这七个字单独地列成旁注内容，这是天方夜谭，根本没人能作出这样的事来。就是这么样简单的一个问题，就是一般中学生都能看出来。当然，没有《康平本》的时候谁也看不出来，有了《康平本》完全都能看出来，而且国内像钱超尘老师这样的在《伤寒论》研究方面一流的专家，都对《康平本》那么的推崇。有人指鹿为马，就坚持这一错误观点，无非就是出于学术上的某种需要，因为要是一旦承认了《康平本》，他发现以前的好多学术观点恰恰不是张仲景的内容和《汤液经》的内容，反而是王叔和的内容，所以他接受不了。其实我们不能去埋怨哪一部分人，人类的学术史上这样的问题比比皆是，有些人走上了那条路还恢复不过来。类似这样的问题就是出在片面，有时候被某些学术观点蒙蔽了，就不能去客观地看。像这方面的事如果延伸一下，现代医学要是粗看感觉最实事求是，研究得很客观，但是它常常闹一些笑话，其实性质都是一样的，问题就出在片面上。

前两天，电视上报导了一条最新的医学研究，说人如果在强烈的日光下久晒容易致白癜风，以前说的是容易致皮肤癌。它这个结论怎么出来的？它是通过日光对皮肤结构的影响得出的结论，但是它不去比较实际的结果。你比如以前的农民，特别是麦收时整天在地里晒得油黑油黑的，你再去调查一下，得白癜风、皮肤癌的是长期日晒的人群里发病率高，还是没有经过长期日晒的人发病率高？这个稍微有点社会常识的人都知道。但是现代医学就愣把这结论抛出来，因为它研究了那些东西就只能看到那一点。

我记得还有一个非常可笑的事，那也是在中央十套节目里大概前

年播的，国内一个一流的产科专家，80多岁的老太太，她阐述了一个问题，就说妇女在怀孕三个月的时候，需要大量的 α 亚麻酸，但人体自身不能合成，必须从食物当中摄取。而且 α 亚麻酸说得也挺厉害，说是影响胎儿智力发育的一个很重要因素。那食物当中什么东西含量最多呢？是核桃。说怀孕三个月的妇女每天要吃17斤核桃。这个结论多多少少都有道理，确实是她从很多数据当中找出来的。但最后的结论太可笑了，一人每天要吃17斤核桃，就是不吃饭一天吃17斤核桃也能把人撑坏了。话又说回来了，倒退50年没有一个人知道 α 亚麻酸，也没有人知道它会对胎儿影响这么大，那时候的人没有去补这个东西，杰出的人不也有得是吗？包括这个教授本人，80多年前生她的时候她母亲也吃不了17斤核桃。这不是笑话嘛！

其实问题非常简单，就是片面。最终的结论你跟临床结果对一对呀。我们学经方也要时常在这个基本点上去提醒自己，不要偏离了这个基本点，不能离开了临床的最终结果。临床的机会少，你去研究研究临床的统计资料，那是最全面的一些临床统计结果。比如说现在最流行的减肥，第一个要做的就是节食。但是就没有人去比较一下，那些肥胖的成为病的人和健康人，实际上他们食量并不大，问题不在吃上，这个不是我们今天讨论的，顺便在此说一说。就是说这些问题都值得我们去思考，而且都是带有根本性的问题。

大阳病、头痛发热、身疼腰痛、骨节疼痛、恶风、无汗而喘者、麻黄汤主之、（35）

麻黄三两去节 桂枝二两去皮 甘草一两炙 杏仁七十个去皮尖

右四味、以水九升、先煮麻黄减二升、去上沫、内诸药、

煮取二升半、去滓、温服八合覆取微似汗、不须啜粥、余如桂枝法将息、

胡希恕：那么，到这儿就开始学习麻黄汤的应用了。那么这太阳病，无汗，它与这个桂枝汤证啊，就是一个有汗无汗的关系，它也发热，头痛发热和桂枝汤是一样的。它就因为无汗，体表的水分相当的多，由于水分多，这个热也重。那么对身上的压迫，对神经的这个刺激呀是无处不疼啊，所以“身疼，腰痛，骨节疼痛”，是无处不疼。那么桂枝汤证它疼不疼呢？也疼，但是轻。桂枝汤证出了一部分汗，排出去一部分，对外边的水分的压迫也轻，存在的毒素也比较的少，所以它疼不这么重，而且也不上波及到肺，它也不喘。这麻黄汤就不然了，它一点汗也没有，所以麻黄汤它脉紧呐，这个脉紧就是血管里有充分的液体呀，就是水分，咱们叫津液，那么它这个不但到处疼，而且它必要波及于肺的，所以“恶风，无汗而喘”。

那么就由于我们人体表啊也排泄废物啊，它这个一点也不汗出，应该由体表排泄的废物啊，都担负到肺上了，所以肺受废物毒素的刺激，它是要喘的，所以古人用麻黄汤治喘呐很有点道理，但是要没有表证这个喘古人不用麻黄的。不像这西医，一遇到喘的就爱用麻黄素，中医不是的，中医得讲辨证嘛。它无汗而喘，有太阳病的证候的话，那你用麻黄汤就对了。麻黄汤这个药物组成非常简单，麻黄这个药配伍桂枝啊，发汗相当的厉害，那么配合杏仁呢，它定喘，这个杏仁咱们都知道了，起下气定喘的作用，这个甘草呢也缓急迫，喘病本身就是急迫的证候啊，那么尤其这个疼，身上无处不疼，这个甘草也缓痛啊。那么这个方子就是太阳病，要是也发热，头痛，身疼，骨节疼痛，无汗而喘”的话，这样的太阳病，必须要用麻黄汤，这与前面的桂枝汤是截然不一样的。咱们一般说呢，桂枝汤叫表虚证，是阳虚，阳证中的虚证，那么麻黄汤呢，叫表实证。这个麻黄汤的煎服法，也是要先煎麻黄，把上沫子去了，煮这么一两沸就行，然后把旁的药搁里头

再煮。这个发汗相当有力量了，不像桂枝汤。

李冠杰：这个条文也是一个顶格条文。

那么下边我们解读一下：

这个“太阳病”，它应该是有所指的。那么他这儿呢，应该说它包括了太阳篇里边第 1 条和第 3 条的全部内容。像脉浮、头项强痛而恶寒，或已发热、或未发热，必恶寒体痛、呕逆、脉阴阳俱紧。这两条你要合在一块儿，基本上就是这儿说的这个太阳病的范畴。但是它这儿呢，就不包括表虚证了。那么整个这个条文实际上就是对太阳病提纲的这两条的一个具体化。言外之意就是麻黄汤证是太阳病中的太阳伤寒，按我们今天的话说，就是太阳表实证。

“头痛”从病理上，一个是这个人体患了表证以后，他有一种自下而上的气上冲的这么一种机制。那么所以说，然后人体的体液包括甚至血液，都随着这个气上冲，造成一种，人体的上体部比下肢要严重的充血那么一种，这个体液比较充涌。特别是头部，就更因为是最上端嘛，这些体液对神经的压迫就比较严重，会造成对神经的刺激，那么他会出现疼痛。另外一个因素呢，就是咱们那个体内本来呢，它随着体液有一些应该作为汗，随汗出去的一些毒素，那么这些毒素呢，因为表实的关系一时排不出去，那么这些东西也会刺激人的神经，也会造成人疼痛。当然他是头部比较首当其冲，比较严重了。

这个“发热”，我们今天怎么理解这个“发热”？这个“发热”实际上是，人体打算恢复肌表功能的这个过程当中，用提高体温的方法来限制体内的那些致病因素，能把它们限制到正常状态下，这个体表的功能也就恢复了。它就是形成这么一种高体温。当然有的时候人没有这个能力了，也就不烧了，没病的时候也是，他也不会出现体温高。那么所以说这是一种，那么换句话说，严格地说这个“发热”只是病的一种表象。它实际上是人体抗病的一种反应。所以说人体发热以后，你不要单独地去，像现代医学方法，它给你吃点药甚至什么的，

叫你强行出汗，达到出汗的目的了，然后体温看着下去了，但是肌表的功能没有恢复，它那些致病的因素还在那个地方，它那个量还是那么大。所以说，等慢慢身体恢复以后，还要还要发烧，而且要如果不发热更糟了，人的免疫力彻底降低了，就到另一层了。

所以说呢这儿，现在你比如说在临床当中，有好多在我这儿看病的一些小孩的母亲，有的就这么说，在你这看病时间长了，后来孩子发烧，我就不害怕了，然后那个我要知道他仅仅是感冒，我就给他弄个姜汤喝，实际就是这样。在这方面我自己曾经做过实验，有一次我好几年了吧，我就是按这种理论思想，我有一次发烧了以后烧得挺难受，然后吃了一点药觉得效果不太好，干脆我就不吃了，我就让它烧，烧到将近 39 度，在那房间里边坐着，看书看不下去，，就觉得只是坐着承受这种难受。后来烧了大概前前后后有 24 小时吧。第一天晚上的七八点钟吧，就这个时候开始体温开始逐渐升高，到了第二天的这个时候，我就想了想，我这一天烧得挺难受的，我何必呢？我就带着药回来了，结果我把药泡好了准备喝的时候，感觉身上有点想出汗的意思，就干脆别喝了。慢慢就是 7、8 点钟这时候，它就慢慢地一点点的，自己坐着就出汗，好啦。出完汗以后，烧就退了。

实际这本身就是一个抗病的过程，所以说单独的退热是不科学的。大家看看中药里边退热的药，你像这个，咱现在这个麻黄汤是不是，麻黄汤它也不是单纯的，如果说你要单纯地为了发汗，仅凭发汗退烧的话，你只喝麻黄就行了。像桂枝、甘草、杏仁就不需要了，实际上不是那样。所以说中医治病要科学得多。

“身痛腰痛、骨节痛”，这个原因就一个，基本上就是说主要的原因，就是因为这个体液大量的集中在体表，包括四肢、肌肤，都停留在这个地方。然后呢，也有刚才咱们说毒素的问题，它压迫神经，你哪个地方是个状态尤其不好，可能那个地方就会表现为疼痛。当然说也不一定像真正的麻黄汤证，也不一定全身关节都疼，出现也没有

问题，不出现他要是麻黄汤证的话，用麻黄汤也一样能治。

这个“恶风”，我们现在在这儿学习这条，你看这古人常把这些个症状，有意识地给你错位。你看这儿有“恶风”，那葛根汤里边又一个“恶风”，实际上像这两个方剂，用恶寒倒比较合适。那么这儿，它用了恶风，是不是在强调方剂里边因为包含了一个桂枝甘草汤证，包括了桂枝甘草汤。这个我想有点勉强了，但是这儿，我们把它当作“恶风寒”来理解就可以了。那么像这个病人主观上怕冷，我想也从两个方面来看。一个方面呢，就是说他体温高，加大了和外界的温差，这是其一。另外一个，他本身就是就在恢复体表的这个过程当中，应该说肌表的正常功能是最弱的。那么这个时候，人可能抗御外邪这种，就是适应外界环境的能力，尤其是体表会显得更不足。那么他就自我调节能力差，就会感觉冷。

“无汗”，这是表实证的一个典型的特征。那么它从机理上说，就是肌表处于一种亢奋的状态，但是这种亢奋的状态恰恰对汗腺的控制能力过强，一下把汗腺控制“闭而不开”，形成这么一种病态。

这个“喘”呢，就应该是在麻黄汤里边，它的主要原因是由于体表的（因为是表实证）代谢功能，体表的呼吸功能几乎都关闭了。所以说把这些需要由体表来代谢的这些东西呀，都加到肺上，所以说呼吸系统啊，负担特别重。而且这个人体呀，大家可以去体悟一下啊，这个人体的这个平衡啊，是一个非常微妙而精准，而且是一个动态的。你在这个人有能力的时候，他自己在调节呀。我们环境温度不断在变化，人的活动的幅度也在不断的变化，精神活动也在不断的变化，那么，你这个身体里边的变化，我们人体自己不断地在调整。当它调整不过来了，你就出现疾病了，它就这么一个过程。你看，咱们看了你平时这个呼吸呀，呼吸系统看着没有问题，但是，大家看一看这个麻黄汤，麻黄汤它治的这个疾病里边啊，好多是肺部的疾病。但是，麻黄本身你要说它是个治肺病的专用药也不对啊，好多肺病用不着麻黄

汤。

那么，麻黄汤的这个肺病是怎么造成的？它肯定有肌表这方面的因素。那么，破坏了以前的平衡了，这个肺部的负担重，它就会造成这种情况。大家想想这个人体的平衡有多精妙啊。你就现在的理解，好多那个，尤其是表虚的人，现在如果说拿一瓶子水喝，两三秒钟马上这个汗就出来了。那么，你要是按一般的推理的话，经过食道喝进去，然后再经过胃吸收了，吸收完了以后进入血液，经过血液再输送到体表，那么，这个过程要是进行下来，得好长时间呢。实际上，你可以想像从人体的皮肤最表层一直到最里边的胃，整个这一个过程当中，体液正常情况下都是饱和的，啊，就这么一种饱和状态，它是不断的推陈出新，不断的新陈代谢，它不断的是这样。所以说进来一点新的，它就应该以小便方式或者出汗的方式去出一点，应该是这样的。所以这个平衡非常非常得微妙，人要想干预它还挺困难。

那么，这一条我们也做一个小结：

在太阳病中，有一种表实证，其症状反应表现为头痛，发热，身疼，腰疼，骨节疼痛，恶风，无汗而喘的，为麻黄汤主治之证。

那么，我们下边看看麻黄汤。这个麻黄汤呢，也是四味药，麻黄三两，桂枝二两，甘草一两，杏仁七十个。那么，麻黄是一个温性的解表药，它是一个典型的发汗药，在这个方剂中的主要作用就是发汗解表。那么，整体来看呢，要如果说把用到麻黄的方剂都做一个粗略的比较的话，也会发现似乎这个麻黄啊，有改善体表，或者说远心端的这些部位的微循环的这么一种功能。啊，特别是你像续命汤啊，里边也用到麻黄，啊，这里边让人感觉到不需要发汗啊，这是麻黄。你像桂枝和甘草构成一个什么？构成一个桂枝甘草汤，那么，这是一个桂枝汤的一个最简方了，所以说在这儿它有帮助麻黄发汗的这么一个作用，同时它可以改善循环系统的这么一个功能。麻黄本身也能强化心脏，吃了它以后人会兴奋，心跳会加快。这个杏仁是一个温性的平

喘的药。那么，在这个方剂当中主要是下气平喘，另外呀，它有通大便的作用。这里边在麻黄汤的治疗疾病的统计资料里边呀有这一类的情况，咱们到时候，我们读到的时候，我们再给大家简单地说。

杏仁七十个，这七十个杏仁我把它测了一下，它是相当于 20g 左右，那么，相当于 20g 左右呢，要如果说要把它折成古人的那个剂量的话，应该是一两一分左右的样子。这个杏仁呢，古人要求去皮去尖，这一点，我想是这样，咱们现在很多人，实际临床当中都不怎么去做，都不去做这个，像去皮尖呀，好多就杏仁原样就用，也没有发现它有多么强烈的副作用。但是，古人有这样的要求。说明什么？说明古人当时对这个药哇，已经研究得非常细致入微了。他实际就是通过临床实践来的。还有这个方剂当中的，我们可以这样理解啊，去皮尖的效果肯定比不去皮尖的效果要好，或者说副作用要小，它可能会有一点点副作用，特别是杏仁那个尖里边，据说是有一些对人体不好的一些物质在里边。

那么，再一个就是麻黄，麻黄要求是先煎，煎完以后，煎上几沸以后啊，把上边的那个沫把它去掉，整个经方里边全是用麻黄的方剂大概都有这个要求。这个我们近代很多人也在临床当中啊，也不怎么按着这个要求去做，那实际在服用过程当中呢，也没有感觉说有多么明显的副作用。这里我们应该考虑一方面的因素，一个我们今天实际用量比古人那个时候的用量小的多，这是其一。那么，再一个呢，就是还是那个意思，古人呀是把这个东西研究的非常的细致，一点副作用也不愿让它有，这个东西能够减轻，就把它减，人能为之的，就尽量去做一下，就这样。但是，我们今天呢，特别是我这个做法，麻黄和别的药一块粉碎的，粉碎完了以后你也不可能再分开了。

下边我们再看看这个方剂的方证，这个麻黄汤在临床统计当中表现出来的症状相当得繁多，统计总数有 140 例。那么，发热 102 例，恶风寒 91 例，头痛 69 例，无汗 68 例，四肢关节疼痛 30 例，周

身酸楚 30 例，咳嗽 37 例；那么，另外还有腰痛，身疼，喘，鼻塞流涕，不思饮食，项强，胸闷等症状，那个都在 20 例以下；在这些资料之外还有多少呢？还有 60 多种症状，出现都在 5 次以下，所以说做统计的人都把它都忽略掉了，那么，我们现在无从去找了。但是，这一点我们应该知道，就是说麻黄汤证出来的症状比较繁多。但是，它有规律在，这是其一。另外一个呢，这个方剂我们后边还会说，在使用的过程当中大部分人都在加减，所以说这个，一个是现代病，再一个就是这些症状都需要我们客观地去分析，既不能把它 100%的全都当作是正确的，又不能全部把它否认了，是吧。

舌质：舌质呢，淡舌 16 例，淡红舌 9 例，红舌 8 例，胖嫩舌 3 例，淡嫩舌 3 例，另外还有几种呢，就是出现次数比较少就忽略了。

舌苔：薄白的 45 例，白苔 8 例，淡白加黄 5 例，薄嫩 2 例，薄黄 2 例，黄腻 2 例。

脉象：有脉象记录的比较多，104 例，浮紧脉 56 例，浮数脉 16 例，浮弦脉 8 例，浮缓 6 例，细数脉 5 例。

那么现代疾病跟大家读一下：

感冒、流感、扁桃体炎、支气管肺炎、大叶性肺炎、支气管哮喘、百日咳、急性支气管炎、肺心病、冠心病、高血压、胸痹胸痛、末梢循环障碍、急性肾炎、前列腺炎、慢性尿路感染、遗尿、尿潴留、荨麻疹、中耳炎、慢性肝炎、妊娠中毒症、产后高热不退、长期低热、三叉神经痛、阿米巴痢疾、复视、鱼鳞病、黄疸、习惯性便秘、膈肌痉挛、坐骨神经痛、肩周炎、关节炎、急性风湿性关节炎、肌肉疼痛、乳腺炎、痛经、过敏性鼻炎、慢性鼻炎、失音、急性结膜炎、风疹、皮肤瘙痒、银屑病、水肿、癫痫、产后外感、小儿痘疹、小儿夜尿症。那么这儿呢，大家看这个麻黄汤治疗表证会带出涉及到这么多的病。还是那句话，临床统计的这些医案，好多都是麻黄汤的加减方。那么

有的呢，虽然作医案的那个作者他自己号称是用的麻黄汤，可能他那个方子里边有麻黄汤的所有药，但是，他一共用到甚至二三十味药，其实严格地说就不应该叫麻黄汤了。这里边有这方面的因素，大家应该知道。

关于麻黄汤的应用有一个非常有意思非常典型的医案，就是用麻黄汤来治疗难产。那么这个医案呢，可能大家都知道，是一个挺有名的医案。就是说一个妇女难产，后来经过好多医生治疗啊，都用一些近似催产的这类药。都没有什么效果，后来请来一个老大夫，一看，发烧啊，脉浮紧哪，头疼啊，没有汗，皮肤干燥。这不是麻黄汤证吗？就给她喝麻黄汤。喝下去一会，微微出汗了，过一会就有反应了，很快孩子就生下来了。那么这个事呢，这个医案看起来似乎有点离奇了，就说这个麻黄汤还能催产？实际上我们怎么理解这个事儿啊？女人在生产的时候，应该说是消耗体能最大的时候，那么这个时候稍微有点医学知识的人都知道，你看女人生产以后，整个一个月子里边，出虚汗哪，体质虚弱啊，甚至以前都不让见风，不让见风这不完全对，但体质虚弱是肯定的。就说这是耗费身体能量最大的时候，但是这个时候，人体的整个环境被破坏了。怎么破坏了？她有一个表证老解不了，体表给她争去了很多能量，这个问题解决不了，好像是就影响到了生产的能力，就是她没有那么大的能力去把孩子生出来。所以说就形成了这么一种局面，当表一解，整个人体就比较协调了，进入到那种把所有的能量都用来生产的这么一种状态。

在临床统计资料当中，它有一个患病的季节。在四个不同的季节里边，春夏秋冬四个不同季节里边，冬天发作麻黄汤证的比较多，相对说发病比例要比其他季节高出一倍。那么这说明什么呢？从这儿，大家不要拘谨于以前的说法，像什么风寒束表啊，这些观点都是值得推敲的。实际上我们今天应该怎么去理解呀？就是说环境温度比较低的时候，人有一种表实证的倾向，大家想想，其实我们现在农村里边

有的条件不太好的，一个冬天不洗一次澡。实际他那个身上整个汗毛孔都是关着的，身上特别干燥，然后身上慢慢积攒的污垢积得挺厚，它就是那个时候容易形成表实证一种状态。咱们比如说还是那么说，你要如果说那种所谓的“风寒束表”，如果说真的是那么一回事的话，那么没有得这个病的，作何解释？如果说夏天没有着风的，他得了麻黄汤证，那有啊。这个医案上有啊，尽管说少一些，也有啊。你怎么解释啊？不能那么解释的。

太阳与阳明合病、喘而胸满者、不可下、宜麻黄汤、（36）
太阳病、十日以去、脉浮细而嗜卧者、外已解也、设胸满胁痛者、与小柴胡汤、脉但浮者、与麻黄汤、（37）

胡希恕：你看看这个也是太阳与阳明合病，不一定下利吧，要冲那句话：“太阳与阳明合病，必下利”，所以这个“必下利”是个倒装句，我也不敢在那一段上就说它是倒装句，就因为看全书。这个要是“太阳与阳明合病，必下利”，这个也不会不下利，它不是，可见那个“必下利”是个倒装句。所以读这个古人书啊，光在片段上看问题就是不对的，所谓断章取义嘛，你要整个看它就不是了。这个太阳与阳明合病，就是太阳病和这个满，咱们阳明篇没讲呐，阳明篇就是胃家实嘛，当然是腹满，那么这个胸满，或者他有大便干燥，这两种病也同时发作的，所以它也叫合病，不过它另有用意呀，等我讲完了。

“喘而胸满者”，太阳病有喘，阳明病也有喘啊，阳明病这个喘呐，它由下及上，比如说胃里头实的厉害，大便不通，胃要是实，实就是停蓄东西多了，讲阳明篇有得是了，所谓宿食这一类的，它往上压迫，胃要是满了它不往上压迫嘛。压迫哪呢？横膈膜，人这个呼吸，

肺是这么呼吸，横膈膜上下配合的，你要一吸气，横膈膜它往下，一呼气，横膈膜往上，肺一张一闭它与这个相配合的。那么如果底下顶上了，它吸不了气了，横膈膜往下压不下去了，所以“腹满而喘”，这是阳明病，这我们后头有的，“腹满而喘”。

那么这个“喘而胸满”，不是阳明病，它是由于喘，这个呼吸短促，使这个胸部的内压增高，这么造成的胸满。那么这个是由于表不解，气不得旁达，往上来，波及到肺这个喘，不可下。“喘而胸满”啊，是以喘为主，由喘而造成胸满的，不是腹满而造成这个喘的，这个与阳明病没有关系，可不要下，就是大便干，也不要吃泻药，“宜麻黄汤”，应该以麻黄汤来解表。那么这段搁个太阳阳明合病是有用意的，就让你鉴别这一个问题，因为这个喘啊是表里共有的一个病，这在临床上很重要啊，他由里实造成的喘，如果用麻黄汤发汗，越发越厉害，要由表造成的喘，你越下越坏。咱们头前讲很多了，这个表证吃泻药，不但表不解，而且引邪入内，这个变化更多了，那就造成坏病了。他就有这个用意，让你注意鉴别。这个麻黄汤证这个喘，是以喘为主，以满为客，由喘造成胸满，它可不是往下边去。这个里实证这个喘呢，它是先满，由腹满往上压迫而后喘。所以在临床上我们问病的时候必须搞清楚，看这个人喘来了，你随便给吃麻黄汤是不行，你得好好问问他，甚至于他喘，不但里边没有实证，而且大便还溏泻，你就更不能给吃承气汤了，当然是麻黄汤证，他这个书啊不是随便这么说。那么这一节看起来没有合病的问题，它就是满与喘同时发作，他特意给你搁个太阳阳明合病，就让你辨证的时候，要弄清究竟是太阳病之喘呢，还是阳明病之喘。认为太阳病之喘，也有喘而满，但是胸满。阳明病之喘，也有喘而满，但是是腹满。但是这两个病啊主要鉴别点，是喘与满哪个为主，要搞不清就容易弄错，所以他特意搁一个太阳与阳明合病，根本呢它不是什么太阳与阳明合病。

这个“已”不是那个“以”这个《伤寒论》本子上是错的。这

一条啊我们在临床上最多见了。那么得这种这个感冒，不一定得十日已去，据我个人这个观察呀，三四天就有这个事，表没有了，但是这个脉呀还是浮，浮可是细。这个细就是津虚血少了，脉浮细就是在表的这个津液也虚了，血液也不足了，它是在表，这个人呢同时也嗜卧。这个嗜卧呀，是这个半表半里，尤其是这个少阳病的一个特殊证候，少阳篇里他都没提，尤其他是个柴胡证，这个一会儿我们可以慢慢地讲。这个在临床上常见的，看到脉细，你再给吃发汗药就不对了，这是“外已解”呀。因为什么？脉浮细。人啊，病入里了，人就是困倦无力而嗜卧，假设又同时发生“胸满胁痛”，胸满胁痛柴胡证啊，胸也满，两胁也疼，这个我们讲到柴胡汤就明白这个了。

柴胡汤里他说是血弱气尽腠理开，他说这个病开始在表，那么人患病的这个机体打算发汗，所以把这个体液都输送到体表来了，你看我们讲桂枝汤讲麻黄汤都是这样子，就打算出汗。可是这个阶段过去了，那么这个疾病在表，（正气）支持不了了，它还与疾病不断斗争啊，但是不能在表了，就打算在半表半里。半表半里就是借助这个肺呀，肾脏啊，就是各种脏器协和的力量吧，由呼吸道啊、泌尿系啊，或者是再由汗腺啊，各方面排出这个病。那么这时候这个表面上啊血弱气尽，我们讲柴胡汤就有了，血也弱，气也尽，它都撤这个防线啊，加强里头防线啊，就像打仗的话。所以在表啊这个津液血液都少，所以“脉浮细而嗜卧”就在这个时间。我们在柴胡汤证里头讲啊，讲的“血弱气尽腠理开，邪气因入”，这个邪也就是往里头走，就在这个胸胁的部位，结于胁下，所以咱们一得这个少阳病，胸胁苦满嘛，正邪在这个地方纷争。我们这段就说的这个，本来在太阳病的时候脉不细，脉虽浮但不细。脉一见细了，虽浮，在体表的这个津液血液都不足了，这个病就有入内之势，如果人再嗜卧，它波及到内脏了，人就困倦了，“外已解”，这是外头这个表证完全解除了。那么这时候看是不是柴胡证，光一个嗜卧还是不行的，如果再胸满胁痛，这柴胡证

是具备了，那就是“与小柴胡汤”。

他这个书啊又怕你误于这一点，说十几天了就这样子，这不一定。他说“脉但浮者”，十几天也好，再日久也好，这个脉但浮，不细，而且也没有这一系列的证候，外证，就是嗜卧呀，胸胁满呀，都没有，那你该解表还得解表，没有汗，还是用麻黄汤，这后头也有。所以在临床上啊，不能有主观，说十几天，这个表证应该没有了吧，他就有吗，就有你还得解表。但是前边这种情形很普通，十几天表不解的也有啊，他怕你固执这个“十日已去”。那么如果“脉浮细而嗜卧”，这肯定是病传变了，这个病都是由表传半表半里，再传里，或者由表传里，仲景这个书是这样的，与内经上不一样啊。内经说一日太阳，二日阳明，三日又跑到少阳去了，他这个书不是的，你们看就看出来了。这个在临床上我们常遇到，那么这个人呐高烧不退，可是摸这个脉啊有点细，虽浮而细，这个人困倦无力，这个时候差不多他要这些病都来了，恶心，胸胁满，也有时候往来寒热，这都是柴胡证。这个时候用柴胡汤为主，没错的。如果口舌干燥，舌再有白苔，你还要加石膏，这个我们在临床上常见着，所以这一段书挺重要，我们常遭遇的事情。那么有的，近几年好了，大概我刚到学院的时候，用柴胡，大家还都不同意，不敢用呢。那阵儿都说这柴胡啊，升散，都怕用它，现在一般人没有这个（想法）了，所以这个在临床上有的时候遇到这个事他不知道用柴胡汤，可是这个病始终不好，有一般的这种高烧，多少日子不退，全是这个问题，就是十日已去，脉浮细而嗜卧，这类的情况遭遇的最多。那么这个柴胡汤，主要以柴胡为主药了，你看看他用的量是半斤，这古人半斤，就是一剂分三付的话，每一付还得八钱呢。黄芩与柴胡这两个药，全是苦寒药，解热去烦。柴胡这个药啊，在本经上说的很清楚，它就是主心腹肠胃间结气邪气。结气，就是结于胁下这个结，所以它治胸胁苦满，它从胸到心下就是胃到腹，胃肠中结气邪气，推陈致新，它的作用就是这个作用。所以柴胡配合黄芩，

既能解热，又能够去胸胁满和痛。那么底下呢，他用些健胃药，人参、甘草、大枣、生姜，都是健胃的，搁上半夏止呕，因为这个柴胡证啊，它是少阳病，它是必呕啊，这个书这一节还没提，但是常有恶心。他为什么搁这些健胃药啊？就是我们方才所说这个脉浮细，津虚血少了。这个津液虚，血少也是液啊，不是咱们那个现在都知道血球了，不是血球少了，血液，血里面那个液体，津液少，血里的液体它也少。那么津液的生成由哪来的呢？由胃来的。咱们讲桂枝汤讲了，所以我们这个外邪所以进里，就因为这个津液在外边不足以驱邪了，所以这个邪才往里头走。那么这个时候啊，趁着没入里，他健胃生津，还得想法来对付疾病啊，所以早先徐灵胎他说这个小柴胡汤妙在人参，就在这一点。可是这病已经进里了，这人参要不得，就不能够再健胃了。他里边已经病进来了，你把门关上了，那就是关着门抓贼吗，那还行了？它没进来，外边的气血已经虚，健胃，就是补中益气这种意思了，所以他在这个小柴胡汤里头啊，他特别用健胃有力的人参。那么另外呢有半夏配伍生姜它止呕的，这个后头讲柴胡证啊咱们再详细讲，这里略略地提一提。所以这个方剂，它既是个解热剂，同时又是个健胃剂，健胃止呕。那么小柴胡汤证啊大概都是胃不好，这个我们在临床上也常见，为什么他呕呢？所以他这个书也是，不呕就是没有少阳病，不渴没有阳明病，阳明病准渴，少阳病准呕，后头再详细讲啊，这个咱们先撂到这块儿。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边，是降两字格排版的这么一个条文。

另外在《宋本》这个条文的后边，附有小柴胡汤的方剂和方后注，《康平本》里边没有。

解读一下：

“太阳与阳明合病”，这儿“太阳与阳明合病”，实际上明显有模仿前边葛根汤条文的味道。但是人家那个条文里边有里证的证候，

这个条文里边没有。所以说，阳明病在这儿比较勉强了。但是要是按着胡希恕先生的理解呢，也有一定的道理，而且我觉得这样理解比较客观一些。

“喘而胸满”，这个“喘而胸满”，在很多方证里边，都能见到。不仅仅是在很多方证，在很多类型疾病也都能见到。但是他们的发病机理却相差很远。要是不能理解到这个层面，你治喘那是很困难的，你很难治准确了。

那么咱们下面简单地做一点分析。

这个喘，我们先对阳性病的喘，就是阳性病表证、里证和半表半里证，简单地说一下。

表证里边的喘，机理是什么？就是因为体表的呼吸和代谢功能下降了，增加了呼吸系统的负担，才造成或咳嗽，或喘，或者胸满，也就是这一条里边的病理。

但是半表半里证的喘，直接就是呼吸系统本身处在一个薄弱环节，首先不能适应机体的内环境，发病了，这也是一种喘。

那么里证的喘，有的是因为里太热，再一个就是胃肠里边有停积的食物之类的东西。这些东西积存，造成下腹部的体积增大，上迫于肺部，影响到肺的呼吸空间没有那么大了，也会出现胸满，咳喘这一类的。

另外、水证、血证、气证都有可能造成喘和胸满的这种症状。

所以说“喘而胸满”，单独说成是太阳阳明合病就有点勉强了。前边葛根汤条文里边，尽管也不是非常典型的，但是必定有里证啊，或呕或下利，而且那个里证还是偏热性的，靠一点谱。但是这个呢，只能说如果遇到这一类的情况，你不要当阳明病去看，就只能这样来理解。这样来理解呢，我们能从这个条文里边获得最大的收获。

对这个条文我们做个小结：

就是患太阳表实证后，以喘而胸满为主要症状反应的，虽然与阳

明病的症状有些类似，但不要误以阳明病施治，仍宜用麻黄汤治疗。这是第 36 条。

第 37 条，这一条应该是出自王叔和之手的这些条文里边，价值比较高的一个条文。完全来自于这个作者的临床实践，就是他临床当中的一个体悟。尽管这个叙述方式跟别人不一样，但是这个地方给了我们一个辨别的医理。

这儿的“太阳病”，我们就理解成整个的一个太阳病，理论上既包括表实证也包括表虚证。但是就这个条文而言，因为后边提到了麻黄汤，所以呢，应该侧重于表实证这一方面。

“十日以去”，这个“以”要按胡老的纠正应该是已经的已，不是以前的以。但《康平本》里边就是这个“以”，其实意思就是说已经过了十来天了，就这么个意思。

“脉浮细而嗜卧”，这个“脉浮细”，说明体表能量已经不足了，就是不足以御外的这种征象。但是我们客观地说，临床当中这一类的疾病未必就是这么一种脉。但是这个地方呢，其实还是比较准确的，脉还现浮，但是细了，细了就是表部的能量已经不足了。这个“嗜卧”，严格说这是一个内科病名，也叫做善眠哪，多卧呀，多寐呀。指的是什么？指的就是困倦欲睡的这么一种状态。这是一个体能下降很明显的指征，也未必仅仅就是这一个症状啊。

“外欲解也”在这个条文里边是非常重要的。一句话。这个“外欲解也”，就是人体已经脱离了表证的病理阶段。但是，病没有好，而是出现新的病了，实际上病又深入了，这个地方是非常好的。今天在临床当中，这样的病人太多太多了，而且现在真正纯表证的病人已经为数很少了，好多人都处在这种状态。

昨天有一个 30 多岁的男性病人，他说我呀，一年要输上几次液，输完以后症状是没有了，但是浑身没劲，状态不是很好，慢慢恢复，过一段时间又得病了，他就是老停在这种状态。我说你前面几年老感

冒，因为你没得到合理的治疗。他说对对对！我老是感冒，感冒了就输液，后来就这样，现在倒是不怎么感冒了，但是身体状态一直不好，老是不在状态。这是一个非常深刻的事儿。

那么讨论一下，实际上这个人体患了病以后，症状消失了，但是病并没好，而是发展到比较深的另一个层面上去了。

后边“设胸满胁痛者”，假设这个时候，患者表现的胸满胁痛这样的症状的话，那么这个胸满胁痛是典型的柴胡证。但是我们从这个“设胸满胁痛”大家有什么感觉吗？凡是顶格的条文或降一字格的条文，用这一类的叙述方式得很少。是什么证就是什么证，很少假设怎么着。这就是不同的作者。

那么他现了柴胡证了，就得用小柴胡汤来治疗。看来这个作者在临床当中经过长期的观察体验，总结得还是非常好，而且这里边隐含着一个非常深的道理。

我在这儿也跟大家简单地说一说，就说这个“外已解”。他临床当中也发现了，就是说没有表证了，就是不发热了，也不头疼了，或者那些表证的症状基本上消失了。但是他病没有好。他已经把这个问题说得很清楚了。表证已经解了，但是又出现别的病了，这不是病又往里边走了吗？按照经方分类，表证是最外层最轻的病，那么病就向里发展了。经方对疾病有一套认识理论，凡是疾病都有三个发展方向：一个是经过正确的治疗，或者自身免疫力增强，他自愈了，这是一个；另外一个方向就是维持疾病当时的这种状态，没有变化，可以持续很长时间；再一个呢，离开了现在这种状态往更深层次发展。你要是细推敲的话，有时候前边的病没有好又出现了深层次的病，会出现这种情况，甚至还会出现三阳合病啊。

人体为什么会出现这种状态呢？就说外层的病没有好，但是症状却消失了，他会在深一个层次得病。这是人体患病的一个规律。

实际人体这些病都是这样，一开始是表证，表证如果身体一路弱

下去，表证没有能力抗了，就进入半表半里，又没有能力抗了就到里证，在里证不行了就到阴证，慢慢地人就不行了。当然在整个过程中，也会出现好的层面的疾病，很多类型的疾病同时发作。只要是人一直弱下去或者一再误治就会出现这种情况。

那么理解这个在临床上有意义吗？非常有意义。我在这儿跟大家说一个我自己的经验，特别是给小孩子看病，其实大人也一样的。你看小孩子啊，我跟你说，你可以去试验。如果说这孩子发烧、咳嗽，感冒了。你问他，感冒以前的那一段时间，他吃饭、睡觉、大便怎么样？要如果说吃得特别好，玩得特别好，大便也非常好（一般小孩子睡觉问题都不大）。要是这样的话，我可以告诉你，这个病可以不给他治。当然说是你自己的孩子的话，你可以不给他治，他很快就会自己好。只要是你想办法让他吃好，休息好，他几天就会好了。如果他好几天以前就开始精神不好，玩得不好，吃饭也不愿意吃，那要感冒了，你一定要重视起来，要认真地治。前边那个稍微给点药，沾点药很快就好了；但是后边这一种，这个时候就要重视。前边那个是人在主动地抗病的过程当中表现出来的一种抗病的反应；后边这一种是人体在不断地降低自己的免疫力的时候出现的一种疾病反应。这是两种不同的，你从治疗上难度也不一样。我在这儿就是给大家点这么一下，大家可以到临床当中慢慢去体验。

“脉但浮者，与麻黄汤”。这里的“脉但浮”，得整体来解读了。为什么咱们把这两条放到一块儿？在《宋本》是两条，那么在《康平本》实际上是一条，非常有意思的。这个麻黄汤跟前头那个是有关联的，这里虽然说是“脉但浮”，但是基础还是上边那个基础，本来就是一个表实证的基础。“脉但浮”从字面上说就是仅现脉浮，或者说就是脉仅现浮象。那仅凭一个浮脉，用麻黄汤是勉强的，前边有个铺垫，所以说呢我们应该整体来解读。而且他说得也非常客观，“与麻黄汤”，这里还有可以斟酌的余地。

咱们也做一个小结：

患太阳病多日，甚至已超过了十几天的时间，如果患者出现脉浮细而嗜卧的症状，则疾病有可能已脱离了表证阶段，此时假设患者表现为胸满胁痛等症状的，应该用小柴胡汤治疗；如果仍表现为脉浮等表实证的话，还应该用麻黄汤治疗。

这一条学完了，我觉得有必要跟大家讨论一个问题，就是读古人的书应该持一个什么样的态度？为什么在这儿提出这个问题来了？因为这一条明显的和顶格的条文或降一字格的条文，不是一个作者，而且这个条文又是一个比较有价值的条文。那么这样呢，我们必须去思考另一个问题，我们读古人的书，应该怎么来看？应该持一个什么样的态度？我觉得总的原则就是：取其精华，去其糟粕。这是一个总的原则。

那么在这个原则下，我们再来看经方理论的精华是什么？是方与证（这是核心），以及在方与证的基础上升华和总结出来的一套理论体系，这是经方的精华。

我们客观地说，所有中医经典的书、中医的典籍，都有精华，也都有糟粕。包括我们现在最推崇的那些顶格的条文，里边也有糟粕，也有我们现在看明显得是不太正确的，尽管少，但是也有。

其实客观地说，一两千年以前的古人研究的东西，如果说没有糟粕，全都是精华，那反倒是不可思议，那倒是不合理的，不客观的，也不合乎逻辑的。是不是？所以说我们应该持这么一个观点，再反过头来看看康平本《伤寒论》里边的这些条文。这些不同排版格式的条文之间，有着明显的差异，咱们不能一视同仁。今天学的这个条文，从《康平本》上显示了不是出自张仲景之手，但是，确实包含着正确的东西，确实是个精华，那么我们就应该在里边汲取营养，就应该继承它。

从客观的角度上来看，实事求是地看，《康平本》里边顶格的条

文，应该是经方理论的核心和基础，里边精华很多，越品越能感觉到作者之高明。降一字格这些条文是对顶格条文的一个补充，有临床经验的补充，也有理论认识方面的一些补充和提高。降两字格排版的这些条文，多偏重于论理，但是所论的这些医理，许多都是跟经方理论相悖的，不是一个理论体系。

虽然说各个条文都有糟粕，也都有精华，但是比重不同：顶格的条文精华最多；降一字格的相比较一下，就次一等，不像顶格的那么精炼；退两字格的很多条文都是悖论，都跟经方理论是相左的。

我们为什么去细究这些东西啊？这里边涉及到对某一个古人的正确的评价的问题。凡是来自于临床的有价值的有精华的这些条文，我们都应该继承。确确实实是错误的，与经方理论相悖的条文，比如第七条，像那样的条文我们就应该严格地跟经方理论分别开来。

大阳中风、脉浮紧、发热恶寒、身疼痛、不汗出而烦躁者、大青龙汤主之、若脉微弱、汗出恶风者、不可服之、服之则厥逆、筋惕肉 、（38）

大青龙汤方

麻黄六两去节 桂枝二两去皮 甘草二两炙 杏仁四十枚去皮尖 生姜三两切 大枣十枚擘 石膏鸡子大碎

右七味、以水九升、先煮麻黄、减二升、去上沫、内诸药、煮取三升、去滓、温服一升、取微似汗、（注）汗出多者·温粉扑之·□一服汗者、停后服、（注）若复服汗多·亡阳遂虚·恶风烦躁不得眠也·

胡希恕：这一节很不好理解，他说“太阳中风，脉浮紧，发热恶

寒，身疼痛”，“脉浮紧，发热恶寒，身疼痛”，方才咱们讲过麻黄汤证，麻黄汤证是太阳伤寒啊，那么它怎么搁个太阳中风呢？它这里头主要的关键在一个不汗出，他不说是无汗，他说这个病啊应该汗出，什么应该汗出？中风应该出汗啊，而不得汗出才发烦躁，那么这是就文字上来分析了，实际他这个。。。。。。。。（音频缺失）。生姜、大枣，这不是桂枝汤没芍药吗。麻黄、石膏、甘草、生姜、大枣、杏仁，这就越婢汤，它这个方子啊就是麻黄汤，桂枝、麻黄、杏仁、甘草，这是麻黄汤，麻黄汤越婢汤合方，它这两个方子合方，就是说麻黄、桂枝、甘草、杏仁这是麻黄汤，与越婢汤合方，越婢汤没杏仁，越婢汤啊是甘草、生姜、大枣、石膏、麻黄，这几个药，这是越婢汤。那么这个合方是怎么弄一个中风呢？由于这个越婢汤啊，它是金匱里头的方剂，它治风水，就是人有水气，水气者就是浮肿啊，同时有外感，古人叫风水，这个风水也是风邪了。越婢汤的主治呢，是身热不断汗出。它这一段啊，主要说的是越婢汤，这个中风从越婢汤这说的，越婢汤应该不断汗出啊，由于他这个病啊又有麻黄汤证，麻黄汤证是表实无汗，由于表实无汗，而汗不得出，那么这个越婢汤是治热的，你看它是大量用石膏啊，他就有里热，所以身热不断汗出。那么由于这个表实，汗不得出，这个热不得外越啊，所以这个人特别发烦而且躁，它是这么个意思。所以他这个大青龙汤证啊，只所以搁个太阳中风，这两个字啊，那么他这个证候呢，确实是一个麻黄汤证，但麻黄汤证呢他又不说无汗，他写个“不汗出”，又多个“烦躁”，这个“烦躁”是石膏证。

由于这一段我们可以看出这些问题，这个中风与伤寒就主要是一个汗出汗不出，出了汗，这个脉也不浮紧了，那么身上疼痛也轻了。要是不汗出呢？不但脉紧，而且身上必疼痛，这是就这个太阳中风与太阳伤寒，这个关键就在一个汗出一个不汗出。它要是个麻黄汤证，他只是无汗他不烦躁，那么这个烦躁就是里头有热。他这一段为有别

于麻黄汤证，那么你看看这一段的文字就看出来了，脉浮紧，发热恶寒身疼痛，还是无汗啊，那么这个不是麻黄汤证嘛，用麻黄汤就错了，所以他在这个无汗与不汗出，在这里头他在文字上有所区别，同时他也不写，身重是伤寒，他搁个太阳中风，他这里头的语义相当地深沉。一方面告诉你分析方剂，这个方剂里头越婢汤就是治风的，可是越婢汤汗出，这个麻黄汤无汗，表实无汗，所以这个汗他叫不汗出，汗不得出，而且还发烦躁，热不得外越啊，它往上攻冲头脑就发烦躁，他是这个意思。

所以他这个不是真正中风病，你看他后头就说了，他也怕你误会到中风啊，“若脉微弱，汗出恶风者，不可服之”，脉浮微弱，那是真正的中风证，咱们头前讲的中风，阳浮而阴弱嘛，脉浮于外而弱于内，汗出。那真正的中风病用这个可不行啊，他在这儿就把这个补充一些，他怕你真认为是中风证，你也用大青龙汤那就不对了，千万不能给吃大青龙汤，“服之则厥逆”。一吃呀大汗亡阳，津液不达于四末，手脚就要凉了，而且“筋惕肉瞤”，这个肉也跳，咱们方才不讲了吗，津液丧失，肌肉发痉挛，这个肉瞤筋惕也是这种情形，它不是拘挛，它是肉跳，也是肌肉当时营养失调。“此为逆也”，这是治疗的错误啊。“大青龙汤主之”，这是在头前有了。

那么这个方剂，头前我们已经讲了，它是越婢汤与麻黄汤的合方，就是应该汗出而不汗出的这么一种里热，表不解的病。主要的呢，证像麻黄汤证，但是烦躁，这个烦躁是石膏证了，所以与麻黄汤证是不一样的，与桂枝汤证更不一样，不要因为中风两个字，而当成中风证，来用大青龙汤，那不行了。这个大青龙汤发汗最厉害，你看看这个用量就知道了，麻黄是六两，一剂是三付，古人开的一剂是三付药，这个六两就是六钱了，我们现在用六钱，这麻黄够重的了，同时这个麻黄配合桂枝，我们方才讲了，那是发大汗的，又加上杏仁、生姜，这都容易发大汗。但是有石膏，也清里热，这个石膏啊阻碍麻黄发汗，

所以麻黄配伍石膏是不发汗，但是麻黄大用，他要出大汗了，所以这个麻黄不能轻用，轻用反倒不出汗，非大量用不可。那么这个方剂也是个挺好的方剂，我们在临床上也常多用，尤其治这种肾炎的水肿，有时候用这个方子。肾炎水肿一般都用越婢加术汤，有的时候有大青龙汤证。但是这个方子呢，我们不要輕易地用六钱。我就遇到这么一个人，我也听人讲的，我也没看到，他自己也不知道怎么就想起吃大青龙汤来了，吃了就是大汗亡阳，吃死了，这个出汗出得厉害。

我们方才讲葛根汤了，那么这个大青龙汤也是太阳病一个发汗剂，这个方剂恶寒也特别厉害，所以在临床上要是恶寒特别厉害的这种太阳病，无汗，那么在葛根汤与大青龙汤这两个方剂，你要好好辨。如果这个人没有烦躁，它（大青龙汤）有石膏，不但烦躁，还口舌干啊，那你就用葛根汤。如果他有烦躁，口舌再干，那就是大青龙汤。这两个方剂啊，都恶寒特别厉害。有一年，我得肺炎，那么就是恶寒特别轻，我那个时候给自己开的（方子），我没用大青龙汤，我用的是葛根汤加石膏，错了，但是也好，不是不好，好了它还回来，我吃了这个烧退了，第二天还有，这么两三天，我自己也是最后吃这个大青龙汤好的。大青龙汤这个麻黄非多搁不可，其实我要是开始吃大青龙汤啊，我不会后来得那么重，我住院住了二十来天。这个对于肺炎，急性肺炎的时候，真正恶寒特别厉害，有用大青龙汤的机会。那么治浮肿，尤其肾炎的浮肿，也有用的机会，但是都得这样子，特别地恶寒，没有汗，烦躁。这在临床上，有一个小儿的肺炎的，这个是一个学生治的，他姓刘，这个小孩子简直就是不行了，住西医院都推出来了嘛，就是用大青龙汤一剂就救回来了，这是小儿肺炎，不是肾炎。这个方子也是常用的方剂。

李冠杰：这一条呢，历来都是在学习上是个小难点，不太容易理解，这个条文是经典条文。在《康平本》上是顶格排版的。但是这个条文里面，我不知道大家谁直在看这本书啊，《宋本》在条文的最后

还有“此为逆也”这四个字，那么《康平本》当中没有。就我们在前面分析了若干次了，这个《宋本》和《康平本》之间，尽管这两个版本都经过近二千年来无数次地传抄，我们发现这两个版本是通过不同渠道传下来的。但是他们的内容却几乎是一样的，就是说条文相差的都是些个别的地方。那么像这样这么明显的四个字没有，应该说原始的《康平本》里面就没有这四个字，那么这是在由《康平本》到《宋本》之间这段时间加上去的。

那么实际上呢我们跟大家已经讨论过了，王叔和第二次整理过，第一次整理完是《康平本》样式，第二次又整理了一次，把所有的注解文字全篡入正文了，在这一次整理的时候他又加了这四个字。

为什么在这儿一直强调这个问题呢？因为自从王叔和整理了这两遍以后，其他人对这个版本，特别是《宋本》，《宋本》因为是官方的版本，对原书这个原样是非常严谨的，他明明发现有错的地方，他也不去做更改，他宁可加说明也不去做更改。这就说明这不会是其他人加的，一般应该是王叔和第二次整理的时候加了那一句。而且从口气上看跟他加的那些旁注口气上非常接近，也都是这个样子“此为逆也”。

那么这个第 38 条还有跟下面那个第 39 条都是说的大青龙汤证。那么大青龙汤证这两条都存在一个不太能让人理解的问题，就说我们在学习的过程中改变一下方式，我们首先从方剂入手。咱们先了解一下方剂，了解方剂治什么样的病，治什么样的证，然后我们再去学习条文，这样会帮助我们对条文有所理解。也就是说我们把整个学习的顺序，每一条学习的顺序打乱一下，把方剂提到前面来。

我们先从方剂开始，那么这个方剂呢，其实也是大家非常熟悉的一个方剂，这个方剂一共由七味药组成，分别是麻黄、杏仁、甘草、桂枝、生姜、大枣、石膏。那么如果我们仔细审视这些方剂的话，这些药我们前面方剂中都有过出现，那么这七味药组合在一块儿，这个

方子里面我们会发现它包括好几个方。

首先这里面有一个麻黄汤、同时又有一个越婢汤，那么它还有麻杏石甘汤，它还有桂枝去芍药汤，如果说咱在辐射的远一点就是桂枝二越婢一汤，那么它去了芍药加了杏仁。所以说这只是药物组成，咱们不涉及它的证治疗。

那么方剂当中用药量最大的是麻黄，麻黄用了六两，所以说这个方剂治疗表实证是非常有力的方剂，这个是毫无疑问的。但是如果说我们从全面地来分析这些药物的话，我们不难发现这个方剂它所对应的啊，首先是比较严重的一种表实证，同时呢，它又有里热，因为有石膏嘛，又有里热。那么这个里热又会造成汗出，它有汗出的机制，但是又因为表实过于严重，汗又出不来而形成了体表停饮，也就是说里热把水分排到体表，准备以出汗的方式散热，但是表实又不得汗出，它就是对这么一种状态。我们从药物看啊，它这个方剂应该是对的这么一种病理状态。

如果我们明白了这一点，那么再理解条文的话就比较容易理解一些。后头方后注里边有一些需要跟大家简单说明的问题，《康平本》在方后注里边有一个缺字符，就是一个方框，这个字儿呢在方后注的最后就是这个缺字符的后边是“一服汗者，停后服”。但是到了《宋本》里边已经没有了，这个这种情况还是很多的，这个书里边。那么这个字呢从我们字面上看啊，它应该是一个“若”字，“若一服汗出”，那么“停后服”。但是，就是大概王叔和在得到这本书的时候，这个字已经看不清或者丢了。那么残缺掉了，或者说被虫咬了，但是那他为了保持原貌，在这能看出当时对这本书的态度，包括王叔和对这本书的态度是相当的严谨的，特别是第一次整理的时候，连这种缺字符他都保留下来了。到了《宋本》的时候呢，也就是说王叔和第二次整理的时候，那就把这些缺字符全都给去掉了，这也是一种务实的态度，因为尽管那是反映了原貌吧，但是它又不能说明问题。我们今天看啊

还是非常可贵的啊。有这个缺字符我们能够感觉到这个版本当初是个什么样子。

虽然说，这个方剂在后世的许多注家来解读的时候都说这是一个强力的发汗剂，但是咱们从方后注当中能够看出来，方后注里边仍然说什么“取微似汗”，同时他后面又跟着有“若一服汗出者，止后服，停后服”。那么这也就是说，实际上这个方剂你要如果说用对了，不应该有大汗出，如果说有大汗出的话，这个方剂对你所对的病人不是特别恰好。

像这个哪，我在临床当中啊有过体会。有这么一个案例。因为我平时用这个方剂的机会也不是很多，来我这儿都是些慢性病比较多，疑难病比较多。那么有个小伙子他得了病以后哪，主诉鼻炎，有点咳嗽，鼻子不通气，脉浮，然后哪，他还另外有个特点就是稍有一点，经常喜欢脸常潮红，稍微有点什么事脸就红了。一开始我就给他小柴胡汤加石膏，他喝了以后诸症都有所减，但是老也好不利索。后来我就问他，他说从来不出汗，后来我就给他做了一个大青龙汤。那么大青龙汤哪，我就告诉他，我说你服它，如果说一旦第一次服完了或者说第二次服了，他出了汗了，后边的扔掉，千万别放着它，扔掉就不要喝了，而且，不要存着，万一被误服了以后，这个药容易出事，我给他说得严重。结果呢，后来他跟我说，我只是服第一次的时候觉得稍微有一点汗，后来他说我觉得扔了吧可惜，后来我就减量服了两天，也没事，他说好多了。后来他就外出打工了。

那么在方后注当中呢，还有一些注解文字，内容也非常浅显，一个说的是一旦汗出多了，他给了一个补救办法。再一个呢，就强调汗出多了以后这种不良的后果。

那么这个方剂的方证呢，咱们先看一看症状，凡是我先读到的症状都是发病率比较高的，依次按着这个顺序。

那么症状呢，像：发热、恶寒、烦躁、无汗、身痛、头痛、口渴、

咳嗽。另外呢还有 40 多个症状，但是都相对出现率比较低，没有做统计。

舌质：红舌比较多，淡红的次之，再就是淡舌，舌苔薄白的比较多，其次就是薄黄的比较多，其次是薄白，白，黄。

脉象：脉象呢以浮紧，浮数，浮缓这么三种脉为主。

那么它在现代病里边有一些什么样的记录呢？治愈一些什么病的记录呢？你像：流感、肺炎、支气管哮喘、流行性脑脊髓炎、麻疹、荨麻疹、风疹、皮肤过敏性丘疹、胸膜炎、急性关节炎、风湿性关节炎、风湿性肌肉关节痛、丹毒、急性肾炎、急性皮肤病性浮肿、不明原因性水肿、急性眼炎、汗腺闭塞症、鼻衄，这是统计到的这些病。

那么通过上边的对方剂的解析，还有这个方剂的应用，包括症状啊，包括疾病啊，我们可以简单的得到下面的这么几点启示。

一个是什么？这个方剂里边所含的所有的这几个方子，除了麻黄汤之外基本上都有汗出这个症状，所以说后边的条文里边说提到中风，实际上就是在强调有汗出的机制存在。这个那我们在解读的时候还要仔细的再分析。

在这个方剂的适应症当中，咱们通过刚才粗略地一听啊，大家可能能感觉到大多数的是太阳病的症状反应，你像“脉浮紧呀，发热，恶寒，身疼痛啊”，这都是太阳病。所以说条文冠以“太阳中风”，太阳病这个意思就是说，概括了这个方剂的疾病反应的一些主要的症状。

那么在它治疗现代病里边有一些水肿类的疾病，那么这就说明什么？说明这个方剂可以治疗水肿，它有祛水的这个功能。那么具体的祛什么水，我们后边学习当中就能学习到了。

咱们有这三点启示，我们对下边的学习，对条文的理解就会顺畅得多。

那么我们现在来解读一下第 38 条条文：

“太阳中风”，那么事实上这个条文，如果说我们把这个条文从头到脚读一下再看看这个治疗方剂，这明明不是一个太阳中风。但是特别是它在“太阳中风”后边马上就跟上一个“脉浮紧”，“脉浮紧”本身就是太阳伤寒的脉嘛，那么为什么这个地方犯如此简单的错误呢？实际上这是古人的一种特殊的论述方式。这个特殊的论述方式还非常有意思，咱们慢慢地就能体会到，等这个条文学完了，大家就有所体悟了。

那么刚才我们讲方剂的时候就已经说了，他之所以用这种矛盾的方式，而且他这个矛盾是显而易见的，一眼就能看出来。你看特别是“中风”后边就是“脉浮紧”，显然是矛盾嘛。那么为什么会矛盾呢？你肯定就要想，谁读这本书他就要想，你再整体地一读就会发现，哦，这个方剂治的这些病都有可能。人有出汗的机制，应该出汗，那么高的里热他不应该有汗出吗，但是它却不汗出。

就是在这种病理机制下才会出现这样的状态：“脉浮紧，发热恶寒，不汗出而烦躁”。这是这个方剂的主要的症状。那么所有这些症状啊，大家看，除了烦躁之外，烦躁本身这一个症状稍微特殊以外，其他的症状基本上都是太阳伤寒的症状的范畴，像“脉浮紧啊，发热恶寒啊，不汗出啊”，这都是伤寒的疾病反应范畴。特别是这儿啊，这个“不汗出”，按这样如果说要在其他的地方，在太阳伤寒的论述里边，它会说它无汗，但这个地方特别用了一个“不汗出”，你看古人写东西真是这个字啊，他推敲得非常的细致。这个“不汗出”言外之意就是说他出汗的机制，它本来应该汗出的但是却出不来，用这个来跟那个真正的伤寒又加以区别。那么你读到这儿，问为什么？为什么你去分析就行了，看看方剂就知道了。

“烦躁”这个症状，在这个方剂里边就有一个它自己的特殊性，它至少有两方面的原因：一个是什么？这个表实严重，表实严重了以后啊，其实单纯的麻黄汤证，人也会有烦躁，难受啊，它身疼痛，浑

身疼它不烦躁吗，但是呢，他又有里热，从病理上是两码事，但是他有这方面的因素。那么第二个方面呢，就是里热严重，这个里热严重，里热本身就能使人烦躁，再加上他里热很重，他把人体的津液尽可能地往体表排，想把它排出去散热，结果呢还排不出去，外边门还关着。那么这个时候他就出现了一种很不协调的状态，反映在人的精神方面就是烦，所以说就更烦，这个大青龙汤证啊确实就是一个非常烦的。

我见过这样的病人，那个特别是你看那现代病里边有个什么病啊？有个丹毒。丹毒像腿的下肢发黑啊，有些皮都快要死掉了，然后凡是要发作的时候它先红，然后就发高烧，高烧以后这病人啊一般不超过半个小时，体温就能到 40 度，然后那个病人就在那躺不住。看他是特别难受，实际上这是大青龙汤证。但是在临床上，因为咱说了啊，纯里热也有烦躁，纯表实也有烦躁，但是大青龙汤证的烦躁比单纯的里热或者说是单纯的表证的烦躁还要重，就是因为上面我们说的这个原因。

那么这个条文他列举的这些症状，我们把它放到一块儿，它也是有所侧重的。那么这个条文侧重什么？侧重于大青龙汤证以表实证和里热证为主要矛盾的一种大青龙汤的适应证。那么它还有别的吗？还有。你像下边一条，第 39 条，说的就是以停饮为主的，所以说他是有侧重的。这一条就是讲像这一类的情况，表实证特别的明显，里热证也特别明显，人又特别烦躁的，这种就是大青龙汤证。大青龙汤就治这个，这个条文就等于是说这个。

那么我们从刚才我们读到的临床统计资料看，在临床当中，历代这么多应用这个方剂统计出来的症状，和方剂当中列举的这些症状，出入不是很大。换句话说，这个条文里边把这个症状列举的还是比较全面的。那么为什么？就是因为这个方剂在应用当中如果说你用得好它可以治大病治急病，但是用不好它就会出大事。所以说呢，就给你说得比较详细，目的就在于避免你误用了这个方子。

尽管这样，下面一再地给强调，应用这个方剂的禁忌症：那么“若脉浮弱汗出恶风者，不可服之”，这就是这个方证的禁忌症之一。你看这个脉弱就说明人体已经有虚象了，或者说也许已陷于阴性表证，或者有里虚等等的一些症状吧。反正这个“脉微弱”它不是大青龙汤证。如果是大青龙汤证，那么严重的里热不会处于脉微的状态，再加上严重的表实证，就算是有停饮的话，第 39 条也仅仅是“脉浮缓”。“汗出恶风”，这强调，实际上这个“汗出恶风”啊，也进一步地佐证了前边那个“太阳中风”不是本意，他不是强调这是太阳中风病，而是说他应该有汗出。真正有“汗出恶风”这种情况这是典型的表虚证，这个方剂倒不能用了。下边告诫“不可服之”。这里一再强调，因为就是说这个方剂容易出事。

那么说你要真误服了会怎么样呢？“服之则厥逆，筋惕肉瞤”，这个“瞤”字也作润字。在这读作瞤字还是比较合理一些。这是又说出一个一旦误用了本方剂以后出现的不良的后果。“厥逆”呢就是说四肢厥冷了，“筋惕肉瞤”，这个“惕”和“瞤”意思是相近的，都是指的抽动，都是说筋肉跳动这一类的症状，这个症状就挺重的了。也就是因为出汗太多肌肉组织失养所造成的这种情况。

这是说的这个方剂在临床当中误用了以后，一个常见的不良后果。但是我们应该客观地去想，这绝对不是唯一的，这只是说是常见的。不管怎么样，当然你要如果说服这个，屡有这样的报道服了一剂，出了大汗，又服了一剂人死掉了，不是一个两个这样的医案，所以说呢这只是说的仅仅常见的一种情况。

那么我们再回过头从这一条来看大青龙汤的适应证：就是一种表实里热并伴有体表停饮的这么一种症状。

下边我们再做一个小结。我在这儿首先跟大家说啊，如果说你有兴趣的话，你可以试着把这个条文用我们今天的叙述方式，你把它重新写一遍，这个条文也不是特别长，也不是特别深奥，你写一下试一

试你马上就会发现，一开始我们解释的时候可能很多人初接触这个条文，特别是按照胡老给我们指出的这么一种理解方式的话，都会觉得有点牵强嘛。古人为什么要绕这么大的弯？用一些明显的自相矛盾的方式来描述这么严肃的问题。当你要如果说试着写一写，你就会发现，你要真想把这种情况写明白了，还真是一个很困难的事情，还倒不如说他这种写法。而且他这种写法还有一个很客观的事，就是古人那个时候跟他当时的生活条件是有关系的，那时候跟我们现在，他也没有多少业余生活，凡是做学问的人都是在社会活动也非常少，而且说如果有一本书，大家想想呀写在竹简的书，像《伤寒论》这么一本书，就是一部巨著了，而且像这样的书，如果真想自己拥有那一定只有去抄它，抄下来以后再反复地去揣摩，所以说在那个时候，再加上书写的时候那个条件限制，就用了这么一种比较含蓄比较隐讳的方式。实际上你从这个意义上看是可以理解的。

那么咱们做个小结呢，就说试着这样论述，大家看是不是可以认可。

当人体处于表实证同时伴有里热和体表停饮的病理状态下，如果症状反应为脉浮紧，发热恶寒身疼痛，不汗出而烦躁的，为大青龙汤主治之证。但是当病证反应为脉微细，汗出恶风的，不可使用本方治疗，一旦误用就可能造成四肢厥逆，肌肉抽搐跳动的不良后果。

伤寒脉浮缓、身不疼、但重、乍有轻时、无少阴症者·大青龙汤主之、（39）伤寒表不解、心下有水气、干呕发热而咳、或渴、或利、或噎、小便不利、小腹满、或喘者、小青龙汤主之、（40）

麻黄_{去节} 芍药 细辛 干姜 甘草_炙 桂枝_{去皮}各三两
五味子半升 半夏_{半升洗}

右八味、以水一斗、先煮麻黄、减二升、去上沫、内诸药、煮取三升、去滓、温服一升、

若渴者、去半夏、加括蒌根_{三两}、若微利、去麻黄、加薤花如一鸡子、熬令赤色。若噎者、去麻黄、加附子一枚、炮。若小便不利、少腹满者、去麻黄、加茯苓四两、若喘者去麻黄、加杏仁半升、_{去皮尖}。（注）且薤花不治利。麻黄主喘。今此语反之。疑非仲景意。

胡希恕：依他这文章啊，给后世造成口实，他这个脉浮缓他弄个伤寒，这个伤寒冲着无汗说的，由于这个病啊他是个水气病，水气病就是体表有水气，所以他身不疼，而但重，人这个组织里头啊，就是肌肉、皮下的这个组织要是停水多就沉。那么身不疼但重，但是没有汗，他也叫太阳伤寒，但是脉内不是那么样子达到充血程度，所以脉是浮缓而不浮紧，它是这么一个病，他搁个太阳伤寒。因为这句话呀，后世注家说大青龙汤又治中风，又治伤寒，所谓鼎足而三嘛，桂枝汤是治风邪的，治风伤卫，麻黄汤治寒伤营，这个大青龙汤治营卫俱伤，搞出这个来了，其实一点也不对，你们看这段也不是伤寒，哪来的伤寒，它是水气病，所以在底下他分析身不疼。真正伤寒达到那么样子充血，压迫身上一定疼。他身上不疼，但重，就是沉，有水气嘛。

“乍有轻时”，这个水气还没达到整个浮肿，整个浮肿就光沉，肿，它没有乍轻时。这个乍轻时说明这个水气呀，还流走，它在这个地方，这个地方就沉，挪到旁处去了，这个地方就不沉了，所以乍有轻时。

“无少阴证者，大青龙汤主之”，无少阴证这句话，也是与旁的节目有关了，这与这个《金匱要略》有关，《金匱要略》有这么一条，

说“水之为病，脉沉小者，属少阴”。“脉沉小”，我们讲少阴病的时候就知道了，少阴病脉微细啊。浮者为风，脉要是浮啊就是风，就是我们说越婢汤那个风，所以这个水气呀，有属于少阴的，有属于风邪的。要是没有水而光胀，虚胀者为气，要是水肿发汗就好。但是少阴病，属于少阴病脉沉小，应该用麻黄附子甘草汤。要脉浮，而不小，不沉小，就应该用杏子汤。你们回去看看《金匮要略水气篇》就有这一段。

那么治水气呀，要是脉沉小这个方剂用不得的，他说的这个杏子汤就是大青龙汤。但是《金匮要略》的注家都不这么说的，因为他们都不对着看，也有说麻黄汤加杏仁的，也有说麻黄甘草汤加杏仁的，《医宗金鉴》就这么说的，也有说麻杏石甘汤，都不对的，应该是大青龙汤。这大青龙汤去水后边有，治溢饮嘛，溢饮这个指水饮溢于外谓之溢饮。那么这个治水气病，大青龙汤发水气是最好呀。那么主要你治水气的话，你看他有没有属少阴的这种情况。那么要真正要是少阴病的这种水气病的，你不能够用大量麻黄和石膏了，那得用麻黄附子甘草汤，那个量都小的很。我们讲少阴病，就有麻黄附子甘草汤了。现在咱们讲到这个地方，不知麻黄附子甘草汤是怎么个事情，现在咱们先不说这些。所以他治水气病，特别提出来了，尤其大青龙汤。大青龙汤发汗的力量也重，解热的力量也重，真正阴寒的虚证，那用这个药是大相反了，那非把人药死不可，所以他特别提出个少阴病。“无少阴证者”，那你吃大青龙汤是没问题的。这不再是脉浮缓浮紧的问题了，这是水气，你看看这节，哪是什么风伤卫，寒伤营呀。所以这个注家就是根据上边这个名，那个叫中风，这个叫伤寒，其实仲景的意思不是这个意思。他这个太阳病无汗者他叫伤寒，有汗者叫中风，那么上边这个没有汗也叫中风，他那个意思应该有汗，而这个汗不汗出，他特意这么提出来。由于不汗出，什么不汗出呀，由于里热，总而言之就是里热。这个里热应该汗出而不得汗出，还有个表实，所以

这两个方剂要喝的，一个有热应该出汗吃越婢汤，一个表实汗不得出就是麻黄汤，所以他把这两个方剂合用。这个地方挺要紧，而且都不好理解。

这个大青龙汤呀不但是一个解表解热的重剂，而且也是一个发水气的重剂，发水气的力量最大，比越婢汤力量大，因为越婢汤里没有桂枝，他这里头有桂枝。

那么由上一段的水气，这个 40 条继续他又谈到水气。这个与我们头前讲的那个，桂枝去芍药加茯苓白术汤，与那节有关系。那节我们讲了，里头是有停水，不利水，表不解，所以他“服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满，微痛”，你们看看那节，这节呀就由这上来的，他说这个心下有水气呀，虽然发汗而表不解，他开始是无汗，伤寒嘛。这个表不解他就是，他搁个表不解干什么，他就是由于心下有水气，一般药发汗而表不解，就是用麻黄汤发汗而表不解。

他怎么就没去水气，那么这个，不但表不解，由于这个发汗药的刺激，激动里水他就变症百出了。“干呕”，那么在这个《玉函经》里头没有干呕，就是咳而发热，干呕也行的，他里有水饮，逆于上他就干呕嘛。“发热而咳”，表不解他发热，里有痰饮充逆于肺他就咳。

“或渴”，这个里有水，看看你的水的代谢如何，如果小便不利，里头停水非渴不可。这个很好理解，由于小便不利，这个旧的水不去，新的水他不吸收，新的水不吸收，我们全身的组织都缺少水的营养，他就渴。后头咱们讲五苓散就有了。这个渴呀就咱们书上说的水不化气，水停不化气，你光喝到里头他不解渴，甚至于消渴。

“或利”，或者这个水在里头，小便不走，水谷不别，下利。“或噎”，这个气往上撞，再有水，水气冲逆，吃东西咽不下去，噎。“或小便不利”，那么小便不利心下才停水呀，或者也有这个证候。小便不利呢，少腹一定满。人的这个膀胱不在这个少腹嘛，少腹就小腹

了，小便不利，膀胱里蓄水，这个小肚子就胀满。“或喘者”，那么这个喘，他一般麻黄汤里都有了。尤其在里头有痰饮，这个表不解，他都往上来，射于肺，不但咳而且还要喘啊，小青龙汤主之。

上边这个一切的情况，那么他主要的就是心下有水气。咳而发热，这是肯定的，这个应该用小青龙汤。那么底下这个“或”已下，或有或无，不必管他，都要用小青龙汤。咱们这个书呀，每个方剂后面要有这个“或或”呀，他都给弄个加减方，这个不对的，所以我向来也不这么用。你们看到后头林亿也注了，这恐非仲景意。他弄的错了，你看我再找个说一下就知道，“若咳去半夏，加瓜蒌根三两”，这都是错的，他这个主证呀，他这个咳不是瓜蒌根治的，这个瓜蒌根治这个咳他是一个燥咳呀，是津液虚那么一种咳，水不化气这个咳他不。尤其其他这个小便不利少腹满去麻黄更瞎闹了，根本这是一个解表的方剂呀，他是伤寒表不解，你去麻黄你解谁去？所以这个书后头加减方呀，每一个都这样，都不要信。用不着的，我们用小青龙汤是常用来治咳治喘，无论小便利不利他都能治。所以他后头这个加减呀，不要信，也不要这么用，他根本是一个表不解为主的，由于这个一般我们辨证来说呀，就是外有邪，就是感冒了，而内有饮，内里头有水饮，就这么一个病，他外邪激动里饮，他这个证候有些或然的症状。看这个饮多饮少呀，人的身体强弱呀，他这个症状百出，不一定，尤其这个里饮这个水饮这个病呀，他是最没有一定。你看底下头晕呀，恶心呀，呕吐呀，这个水饮这个心悸呀，水饮的这个证候多去了。我们只要依证去水就行，那么有表证的当然宜小青龙汤。

小青龙汤这个方剂呀，他是以麻黄芍药甘草来解表，其它的药都是一些温中去饮的这么一种药，细辛、干姜、五味子、半夏，也去饮也治咳。饮逆，你看半夏也去水，这个五味子也去水，咱们五味子都知道治咳了，他是一个去水的这种镇咳药，他有收敛作用。那么细辛干姜都是温中去饮的药。那么里头去饮，你这个麻黄桂枝才能发挥解

表的作用。如果里头不去饮，那伤寒表不解，那你吃这种发汗药也不行。而且还很容易造成很多的坏病。所以这一篇呀和我们头前那个一样。

但是我们用这个方子要注意一点，它必须是偏于寒，尤其咱们说的饮呐，它是一种寒饮，那么起码这个病它不渴，这个“或渴”呀，是由于误治啊，我们给吃了麻黄汤了，他激动里饮，有这些特殊（情况）。一般不渴，因为里有水饮它不渴，同时呢口舌也不会干的，要不然干姜、细辛、五味子、半夏这些要下去太燥了。所以我们用这个方子要注意。但是真正的老人这种痰喘，用这个方子的机会还是非常的多，他痰呐没有黄痰，白痰而且是泡沫痰，这种情况之下大概要有外感的这种痰饮咳嗽和喘，用小青龙汤的机会不少。要有热象千万不要用，如果烦躁呢用小青龙汤加石膏，这个药加石膏在《金匮要略》里就有了，我们方才大青龙汤不是不汗出而烦躁吗？那么小青龙汤要烦躁呢，一样加石膏。

李冠杰：这个条文在《康平本》里也是顶格的条文。

条文当中的“大青龙汤主之”，《宋本》为“大青龙汤发之”，没有原则的差别。但是呢，相比之下《宋本》强调了这个汤的作用。有通过发汗的方式，驱表停饮的这么一种作用。

下边呢，我们解读一下：

“伤寒脉浮缓”，跟 38 条论述出了相同的问题。伤寒本身应该脉浮紧，但这儿呢，前边是伤寒，而后面跟上脉浮缓，脉浮缓明显是中风的脉，这又是自相矛盾。他之所以这样写呢，意思在要强调这个疾病的性质。脉浮缓之所以跟在伤寒的后边，让你去再分析分析方剂，再去看看症状，实际上他就强调有停饮证在里边。

“身不疼，但重，乍有轻时”，我们看这个条文，应该结合上一个条文，因为是同一个方剂所主。所以说前边有伤寒，其他的一些症状，就不去详细地论述了。在这儿详细论述有特征性的，像“身不疼”，

按照上一条的论述身痛才是对的。但是这儿呢又给你强调身不痛，有一种情况还是身不痛的，但是重、沉。有时候还“乍有轻时”，这就是在强调体表停饮的。他把这些有特征性的症状都列在这个地方，他在这个地方想说的是什么呢？表实证不重要，是以停饮为主要矛盾的。后边有“但重”嘛，这个重，是身重，身重是肌肉组织停饮的一个典型的症状。

为什么人会感觉的身重呢？肢体沉重，我们要稍稍仔细想一下，这个组织里边如果停饮的话，就是含的水分多了。含的水分多了以后，肢体就沉重。

有时候阴天想下雨又不下，这个时候如果活动或劳作，体力活动稍微重一点，水分就排到体表下边，但是外边气温又不那么高，他也形不成出大汗，这时候就觉得越干活越没劲，也没有精神。反倒不如在很炙热的太阳下边，边干活边出汗，汗出的眼都睁不开，那个时候越干活反倒越有劲。

这是停饮会造成肢体沉重的古人总结，应该都是来自于临床实践。停饮是什么？停饮就是应该代谢出去的水分代谢不出去，实际上就是废水增多。废水增多了以后，就会影响新鲜水分的供应。新鲜水分也是一种营养嘛，肌肉会某种程度的缺少营养，这时候你也会觉得无力。

这就两个方面的因素了：一个是四肢重，再一个力量小了，就觉得身重了。

“乍有轻时”，这是大青龙汤证的特征性的症状。为什么唯有大青龙汤证才出现这种情况呢？我们刚才说了它的机理有里热。里热就是人体机能偏于亢奋了。有时候停饮重了，他就感觉到身特别重。但是因为人体本身偏于亢奋，有时候亢奋劲儿上来以后，还能使体液的代谢短时间内又恢复正常了，就把一些旧的水分排出去了，新的水分又到了，这个时候就感觉身体轻松了。轻松了以后慢慢又沉重了，病

没好嘛。之所以形成这么一种特殊症状，就因为人体机能在偏于亢奋的一种状态。像四逆汤证、真武汤证那个人特别没有精神，很少出现一会儿好了，一会儿又不行了。这种情况就不明显。

“无少阴证者”，是一个旁注内容。这个旁注放在这个地方就非常得贴切。要真有少阴证的话，只要像个阴证，不管是麻黄附子细辛汤证、麻黄附子甘草汤证还是桂枝加附子汤证，一旦服了大青龙汤，那就非出医疗事故不可。

第 38 条所论述的是大青龙汤证当中，以表实里热为主要矛盾的一种病理状态；这一条强调的是体表组织停饮。这个条文和第 38 条互相补充，就形成了大青龙汤证适应症的一个全貌。大青龙汤不仅治表实里热同时还治体表停饮。但是临床统计资料当中，用来解决体表停饮的也不是很多。因为对这个方剂的理解，历代始终都有偏差。又是祛风又是治寒、风寒两解，弄了一大堆名堂。到最后不知道这个方子该怎么用。而且带着那样的理念去用，到最后非出事不可。

还有《金匱要略》里面有这个方剂和小青龙汤的论述，那个论述实际上就是说了第 39 条的病理状态。那是水气病，这儿实际上说的也是水气病。这一个方剂既在六经里面，又在《金匱要略》里面那种论病的方式出现了。这也说明了当时古人写这本书的时候，就没想用六经去囊括所有的疾病，而是给你论述疾病、鉴定疾病的一种全新的方法。在当时来说这确实是一种全新的方法。

尽管这个方剂有很强的祛体表停饮的功能，但是在临床应用当中应该注意，必须有大青龙汤证的基本特征：一个是他得有里热，有里寒的那是小青龙汤证；再一个就是得有表实证，一旦有汗出了就不能用这个方。这是最基本的，你别紧盯在体表停饮上，看看他具备不具备这两个基本条件。如果不具备这两个条件，肯定不是这个方剂的治疗范畴。再去找别的方证。

下面做个小结：在大青龙汤的适应症中，还应有以体表组织体液

代谢不良为主要矛盾的症状，但乍有轻时。这也是大青龙汤的主治之证。

咱们学了这两条以后应该有一个明确的问题，两条的论述自相矛盾。对这种特殊的论述方式我们应该客观地实事求是地去看。

第一我们应该从中吸取正确的东西。最起码得读懂它的真正意思，读懂他真正表达的意思。这是一个。其二古人写这个东西不是特别难懂，你只要抓住规律全面地去看待它，你再去看方剂就行。

有人解释说因为条文里边有“中风”这么个词，所以说大青龙汤也能治中风。那不是胡闹嘛！你要是真治中风那还了得，那不得出事儿？是不是？所以说应该去看看方剂，稍微活动活动心眼就能明白的事儿。这里边确实实有缺陷，有不足，容易给后世的读者造成理解上的困难。

这个条文在《康平本》里边和 39 条是同一段内容，这也有意思的。但是在《宋本》里面把它拆开了。另外《康平本》中的“小便不利”，《宋本》加了一个“或”字，这个我们在后边也做了简单的分析。《康平本》中的“小腹满”在《宋本》里面为“少腹满”。

这个方剂后加减有许多处，《康平本》和《宋本》有点儿小的差异，有点出入。咱们在那个时候再具体地看。

下边我们来解读一下：

“伤寒表不解”，“伤寒”在这个地方就是说的太阳表实证。这个“表不解”非常有意思，这一句话他不是平白无故地放在这个地方的，也不是说这个人得了伤寒还没有好。不是那个意思。这也是古人的一个特殊的论述方式。“伤寒表不解”本身隐含着服了麻黄汤一类的发汗药以后仍不解。这个“表不解”还有一种倾向，就是说伤寒吃了发汗药以后，本来应该好，换句话说就是你治得对，你对的这个证是对的。但是为什么“表不解”呢？这又提出了一个新的问题，那么你带着这个问题再读就是了。在这儿还有另一层更深的意义：表证如

果同时伴有停饮的话，单单解表是解不了的。他绝对有这一层意思的。这个地方你只有这样理解，理解出这样的观点，再来看这个文字，确实有十足的价值。你才能看出古人用字的精妙。

“心下有水气”，这就是吃了发汗药以后，表不解的原因。因为还有一个因素没有治疗到，那就是“心下有水气”。里有停饮的这种情况，单独发汗解不了表。“心下有水气”，我们现在就应该理解成里有停饮。而且“心下有水气”，这是对病理的论述。这种对病理的论述，在顶格条文里非常少。这是不多的一个条文。这个病理就是“心下有水气”，有停饮的情况。

“心下”这个地方，指的就是胃脘，也就是胃部这个地方。但是具体到小青龙汤证呀，不仅是心下的问题了。水气呢？本身有两种解释：一个是病名，就指的是水肿；第二个是病症，这个地方，指的就是病症。这个病症就是水饮，痰饮。

“干呕，发热而咳”。这是小青龙汤证一堆典型症状反应的一个症状群。“干呕”就是只见呕而吐不出东西来。一般的理解就是胃中停饮加上气上冲，造成欲呕的一种症状；“发热”，典型的表证；“咳”，在这个方剂当中就比较复杂，应该有这么几个因素：

一个是表实证造成的咳嗽。

再一个呢，小青龙汤证就有停饮的存在，而且里虚还偏于寒。这时候可能肺部有停饮的这种情况，也会造成咳嗽。

还有一种情况，就是停饮主要集中在腹部，整个腹部里边胃肠水肿。使得整个腹腔的空间变得非常拥挤，往上上迫于肺，出现肺部的呼吸空间不足了，造成肺部不适而咳。

前天有一个比较重的病人，他家人来跟我说，这两天开始咳嗽，一动就咳嗽。老喝水，口老干，我给他五苓散。晚上拿走的药，第二天早晨就给我打电话，说：你这药真管用，服下去一会儿就再不咳嗽了，整个一夜都没有咳嗽。后来我就跟他说，他这个咳嗽不是肺有了

毛病，而是他满肚子的都是水。这么跟他解释，病人能听得懂，就是腹腔里边占的空间太大，所以他一动就咳嗽。

我们为什么把小青龙汤证的咳嗽解释这么详细呢？实际上在临床中小青龙汤证常伴有咳嗽，但是咳嗽的情况不一样。情况不一样，你也不要认为他不是小青龙汤证，你要是理解了小青龙汤证咳嗽的几大方面原因，你就会想到。你比如说，有个病人他告诉我，他老是咳嗽，想一想他是不是小青龙汤证呢？我顺便问了，你晚上睡觉躺下咳嗽吗？他告诉我说，他晚上睡觉一点都不咳嗽，结果最后，还是用小青龙汤给治好的。你如果单纯的理解成一个因素的话，恐怕就要失去这次治疗的机会了。

下边是一大堆的或然证。这些或然证有一个前提条件，所有的这些或然证都是在小青龙汤证的病理状态下发生的：既有表实证，又有里饮，又有里虚寒的倾向。

“或渴”。这个渴是一个比较特殊的结果，把它放到或然证里边，可能会出现。有两种可能造成渴：

一个是停饮过于严重，跟五苓散的病机相似，旧水不能排除，影响新水的吸收，可能会出现口渴。

另外一个，服用解表剂发汗有可能造成。按胡老的说法是激动里水。但是我想啊，实际上是发汗以后，加重了人体内部体液代谢障碍的程度，使体液代谢更不正常了。但是机理是一样的，就是因为体液代谢不好，才造成口渴。不是因为有里热，一旦有了里热，就不是小青龙汤证了。

“或利”就是说下利。下利呢，就是水谷不别了。本来应该通过正常的代谢渠道代谢出去的水分代谢不出去，水分都进到胃肠里边，从肠道里边排出来，造成下利。

“或噎”，指吃食物的时候，突然地噎塞了，但是一会儿他还能好。跟干呕在病理上比较相似，就是胃中停饮再加上气上冲造成的。

“小便不利，小腹满”。有意思的是在《康平本》里边没有“或”字。从另一个角度来理解，“小便不利”本身就是一个症状反应，但是同时又是这个方证的一个病因。那么在这个地方呢，可能是特意没加这个“或”，以示跟别的或然证有不同的地方。这个“小便不利”和“小腹满”是一个相同的问题，一旦水停下焦，就出现“小腹满”这种情况。

“或喘”，这个喘跟前边的咳嗽是一种类型的疾病，而且病因也非常相似，咱就不再重复了。

那么从这些或然证里，大家是不是能体悟出这些事儿来了呢？这个方剂的使用，这个方证的总结，绝对不是一时半会儿总结出来的。事实上，所有的经方都有这个特性。你看啊，在临床当中，得看多少病人，慢慢地积累、总结出来这么多。而且还得是这个病人出了这种状态，用小青龙汤治好了。那么，他要是出现的那种状态，你想不到用小青龙汤呢？想不到用小青龙汤，你这次机会就失掉了。这个人出了这种状态用小青龙汤治好了，那个人出现那种状态用小青龙汤治好了，慢慢地这么积累起来，才积累了这么一个方证。后边这些或然证发生的几率，明显要低于前边列举的那些症状。所以说这是一个经过了长时间的考验的东西。

同时呢，这些或然证又给了我们一个提示。中医里边不是有一句俗话叫“凡怪病，当责有水”。就是说有的怪病，去看看有没有停水的因素在。从这些或然证上我们也能看出来。这或然证是什么意思呀？这个人可能表现这样，那个人可能表现那样。为什么从小青龙汤证里说出来呢？因为小青龙汤证可能是里外都有停饮。实际上这就反映了人体患病以后，特别是体液代谢发生障碍以后，他的表现形式是多种多样的，千变万化的。也反映了人体的一种不均衡性。

什么叫不均衡性？前边我们举过一个苹果的例子，同一个苹果树上苹果长得有大有小。

我们再举一个跟疾病关系比较密切的例子。昨天有个人咨询我个事儿，脸部或是哪个地方长色斑，包括老人斑这个道理都是一样的。长色斑的机理，不管是现代医学也好，传统医学也好，基本上说法不一样，但是原理是一样的，都说的是一个事儿。血液循环不好，应该通过血液带走的垃圾带不走，沉积在皮肤下边。可是有这么一个事儿，这个人在眼皮下边有一块斑，或者在眼角这儿有一块斑，那么它的周围为什么不长斑呢？为什么偏偏这个地方的垃圾带不走呢？实际上就是这个地方的状态比周围的组织状态稍微差一点。表现出一种不均衡性，他不是均衡的。假设整个皮肤都是非常统一的，都在一个绝对的水平面上，功能都在一个相同的状态下，那么他就不会在一个地方发生色斑。而可能是浑身的皮肤颜色发生变化。有的人这几年特别黑，过几年以后，他身体好了比以前白一些了，也有这种情况。但是色斑这个问题，确确实实无法作别的解释，就只能解释人体有不均衡性。

其实，咳嗽呀，或者说下利呀，这一大堆的或然证，就是反映了人体患病以后的一种不均衡性。

小青龙汤证的病理：表实证同时又有停饮而且有里虚寒的一种病理状态。

下面作个小结：患伤寒后，服相应的发汗药，表仍不解的，则患者可能有停饮的情况存在，如果在表实证的同时表现为干呕、发热而咳，或渴、或利、或噎、小便不利、小腹满或喘的，均属小青龙汤主治之证。

有一个问题要和大家说清楚，第40条和第39条在《康平本》里边是同一个条文。为什么把这两个方剂放在一块来论述呢？因为这两个方剂都是表实证同时又兼停饮。但是，一个是里热，一个是里寒。把这两个方剂放到同一段里面论述，既可以互相佐证又可以互相鉴别。这也是一种比较高明的论述方式。在《金匱要略》里面，这两个方剂也出现在同一个条文里面。

伤寒心下有水气、咳而微喘、发热不渴、服汤已渴者·此寒去欲解也·小青龙汤主之、（41）

胡希恕：这一节就说明小青龙汤的应用，主要的证候是不渴。那么伤寒没有汗，这类的表证太阳病病型上来讲，它是伤寒。“心下有水气”，就是有水，古人把水呀也叫水气，咱们《金匱要略》里面的水肿，他就叫水气病。水是这样，津液在仲景的书里常叫做阳气。因为这个水它能化气，所以津液他也叫做阳气，后面有慢慢的讲到那再说吧，现在说多了让人更糊涂。

他说伤寒，心下有水气的病，咳而微喘，伤寒表不解呀，他有外邪里头再有饮，这个外邪冲动里饮，就会咳逆微喘，这是很常见的病。发热有表证了，里头有水饮它不渴。“服汤已渴者”，服汤已就是吃小青龙汤。小青龙汤是外解表而内去饮，表解了饮去了，它就要渴了，因为小青龙汤是热药啊，饮没有了，他感觉胃中干他渴。这个渴是服小青龙汤之后，一个效验的表现，就是有效了，他渴，所以它底下注解的几句话，“此寒去欲解也”。这个“寒”指寒饮，这个水气去了，这个病要好了。这个“小青龙汤主之”啊，应该在“发热不渴”之后。应该是“伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴，小青龙汤主之”，不是吃完药渴了寒去欲解再小青龙汤主之，这是一个叉句，是“伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴，小青龙汤主之”。服汤已，吃完小青龙汤了，这人渴了，这是服药有效之验了，那寒气欲解也，它是这么一个文章。

头前这几节是由麻黄汤开始，讲的大青龙汤、小青龙汤，那个柴胡汤啊是讲麻黄汤传入半表半里的时候，它叉这么一节，它主要讲的是解表剂。他由桂枝汤讲到葛根汤，然后麻黄汤，大青龙汤，小青龙汤，这都是解表剂。你像葛根黄芩黄连甘草汤那也是解表。那么在四

十一、条个以下，在解表两个主要方剂就是麻黄汤和桂枝汤，他主要要分析这两个方剂的应用。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格条文。其中有十来个字是旁注内容。

解读一下：

这条和前面的第 40 条没有本质的区别。但是这条在强调没有经过发汗，又现这个方证的，仍然属于本方的治疗范畴。这一点也挺重要。很多人在理解经方理论的时候，常把病因看的很重，认为古人说了这是发汗以后产生的症状，没经过发汗能治吗？这条等于给举了一个例子。从这儿再进一步地往深里想一下，在经方理论中影响治疗的关键因素不是病因。你看第 40 条和第 41 条就能看出来，这两条论述的是一个病。一个是说经过发汗治疗以后，没有治疗如果也是这种表现的，还得用这个方子来治。实际上这个病因是帮助我们理解病理，区别这个疾病的性质，帮助我们辨证的，它有相当重要的作用，但是它对治疗影响不大。这一点是经方理论的一个很重要的特点。其他任何医学都在强调病因，传统中医里有“风寒暑湿燥火”等等，甚至都包括什么季节什么的那一大堆东西都罗列上。现代医学也是细菌、病毒，甚至有的卫生部的专家发现怎么着也躲避不了细菌的侵蚀，东西都不敢吃了，最后把自己给饿死了。所以经方的这些东西，你越深究、越去反复地玩味，就会觉得它所蕴含的道理就越深，而且价值越高。因为它是来自于实践的，它是正确的，你可以理解不了它，但可以逐渐地深入理解它。

“伤寒心下有水气”，刚才说了未经治疗，表现为“咳而微喘、发热”。实际上这些症状也不外乎第 34 条、第 40 条说的那些症状。

“不渴”是在这条里要强调的，应该有它的意思隐含在里面。首先“不渴”是这个方证的一个常见症状，所以作为一个典型的症状列在这个地方。临床当中，真正是小青龙汤证表现为口渴的非常少，

最起码我没见过。有可能它有里热的话会口渴，那就不是小青龙汤证了，最差也是个小青龙加石膏证了。这是一个常见的症状，因为它有寒饮嘛，也印证了前面那个“口渴”在某种程度上除了停饮的因素，就是跟发汗可能有关。再一个意思就是强调既有停饮又没有里热，这一点也非常重要。一旦有里热，要么是大青龙汤证，要么是小青龙汤加石膏证，也应该包含着这个意思。

下面有一个旁注内容“服汤已渴者，此寒去欲解也”。这可能是这个旁注的作者临床当中一个经验，本来的意思就是说服了小青龙汤以后，这是有效的一个征象。实际在临床当中，小青龙汤证服了小青龙汤以后很少出现口渴的。因为它本身就有寒，把寒给它去了，没有寒了，也没有饮了，这时候人正常了，为什么会渴呀？这个很少出现。出现这种情况，恐怕本来应该是小青龙汤加石膏证，没有辨好证，该加石膏的没加，可能会出现这种情况，我觉得这种可能性比较大。这个地方在《宋本》上看不出是一个旁注内容，它跟正文是一样的，而且列在小青龙汤主治之前。从内容上看，它又跟原文明显地有不能接轨的地方。所以很多人都把它解释成是倒叙的一种方法，就是说倒插的。这就能看出把旁注内容篡入正文对读者的误导。如果任何一个人见到《康平本》的话，就再也不会这么解释了！所以也进一步地可以看到《康平本》的重要性。

这一条列举的症状很少，比较精练，或者说不太全面。但是按照读古人的书的正确方法来理解，实际上还有很多的症状已经包含在里面了。因为前面有“伤寒心下有水气”，“伤寒”就包括了一大堆的表实证的症状，像发热、恶寒，头痛，甚至包括身疼痛，这都完全可能出现的；“心下有水气”也不是说的一句白话，尽管是对病理的解释，但病理是以症状的形式反映出来的，它有“心下有水气”相应的一堆症状，这些症状在前面的或然证里都包括很多了，看看方剂也应该知道。

下面我们对这条作一个小结：阳性表实证同时又伴有停饮，其症状反应为咳而微喘，发热不渴的，为小青龙汤主治之证。

下面再看看方子。小青龙汤是个常用方剂，由 8 味药组成：麻黄、芍药、细辛、干姜、甘草、桂枝、五味子、半夏。麻黄、桂枝、芍药、甘草这四味药，我们可以把它们理解成小青龙汤的一个方规，或者说是小青龙汤的一个组方之一。如果把这四味药看成一个方子就很容易理解了，这药咱们前面都学过，无非就是桂枝汤里的主药和麻黄汤里的主药，它的主要功能就是发汗解表，这是很明确的！另外像细辛、干姜、五味子、半夏，这些药也挺有意思，它们有一个共同的特性就是温里祛饮，而且它们都有治疗喘和咳嗽的功能。可是治疗的却不是一种情况：像五味子和干姜，干姜也能治咳嗽，像理中汤还治因为里寒造成的咳喘这类的病，实际上主要还是干姜的功能；五味子也治咳嗽也祛饮，但是它们治的不是一类。其他的药也都有类似的特点，它们都治各自不同的原因造成的咳嗽。小青龙汤证的一个很重要的典型症状就是咳喘。为什么小青龙汤治咳喘这么好呢？就是因为它是从多方面的、大的方向就是温里祛水具体治咳嗽；前面的四味药它还有一个解表的功能，解表本身也能治咳嗽。所以说这个方剂在临床当中治咳喘的机会是比较多的。但是得有小青龙汤证，得符合小青龙汤的适应证，不符合是治不了，仅仅是盯在咳嗽上那也不行。

下边看方证：

症状：喘、咳嗽、咳痰、恶寒、发热、胸闷、干呕、下利、渴、小便不利、胸满（胸闷）、纳呆、水肿、周身乏力、流涕、头痛，这是主要的症状，还有若干症状因为出现的几率比较低，就没有统计。大家明显能感觉出来，小青龙汤所治的这些症状都比较繁杂，面也比较宽。

舌质：以淡舌、胖淡舌和紫暗舌。胖淡舌能体现出有停饮的一个特征。

舌苔：以白苔为最多，另外还有薄白、白滑、黄白润、黄腻。

脉象：脉象弦滑、弦紧、浮紧、浮滑、沉紧、沉弦、滑，就这么几种脉象。

现代应用看看小青龙汤治愈记录的现代疾病：流行性感冒、湿性胸膜炎、结核性或渗出性胸膜炎、大叶性肺炎、间质性肺炎、急慢性气管炎、支气管哮喘、喘息性支气管炎、肺结核、肺气肿、肺心病、百日咳、小儿手足口病（这个小儿手足口病是日本人的经验，那么是不是我们现在的手足口病有待证实）、急性腮腺炎、青光眼、结膜炎、泪囊炎、虹膜炎、慢性鼻炎、过敏性鼻炎、急慢性肾炎、肾病综合征水肿、荨麻疹。

下边我再跟大家说说我应用小青龙汤的医案，因为小青龙汤是一个应用机会比较高的方剂。说三个我的医案，都有自己的特点，咱们从中体悟一下临床当中应用小青龙汤。

有一个医案是我同学的母亲，80多岁了。我同学打电话说他妈妈感冒了，先输了7天液，以前感冒输上7天差不多就好了，但这次没好，后来又输了7天还不好，就不敢再输了。这老太太的女婿是我们这儿医院里的一个主任医师，他知道抗生素的副作用相当大，也经常在家里边说，所以老太太就不敢再输了。就想着看中医，给我打电话说能不能去看看，我就去了。她有个很重要的特点：除了一大堆感冒症状以外，就是咳嗽，咳嗽的睡不着觉。很胖的一个老太太，她说晚上咳的都睡不着觉，越躺下咳嗽越厉害。大家注意啊，这个医案是以腹部停水为主要特点的。为什么啊？因为她到医院里边做胸透去检查了，肺部有很轻微的炎症，几乎都可以不称其为病，但她老咳嗽，连医院里都束手无策，不知道该怎么治。我经过辨证以后就给她小青龙汤。因为是熟人，再加上她年龄大，心脏也有点不好，小青龙汤里有那么多的麻黄，我晚上就在那儿坐了一会儿，等她服完药以后大概一个多小时，没有明显的感觉，我就又让她服了一次，后来我就走了。

到了第二天，我顺路去看她，她就说：“我昨夜到了下半夜（她第一次服药是晚上以后了），哎呦！我开始能睡觉了，今天午饭以后我又开始睡，睡了差不多大半个下午”。咳嗽也明显得轻了，而且她腿的水肿的皮肤开始变松了。第三天我去看她，一进门她就给我说：“冠杰啊！我该怎么谢谢你啊！你给我治好了这个病”。她说感冒咳嗽一点症状都没有了。后来根据她当时的情况，给她喝了一点别的药就好了，小青龙汤就喝了三天，六剂。这是一个医案。

另外一个好像说过。这个人每天早晨锻炼，不到 50 岁的样子，已经坚持了十好几年了，每天早晨要快走一个半小时多。他去年冬天就开始咳嗽，他的特点是晚上一点都不咳嗽，而且睡得很好，到白天就咳嗽得挺厉害。我经过辨证以后，他除了脉象有寸关沉细，迟脉，多少有一点浮象之外，其他的几乎没什么症状，像大小便、睡眠什么的都很正常，这就等于近乎无证可辨。我一开始就觉得是个小青龙汤证，但是他晚上一点也不咳嗽。我就问他：“你有没有手脚发凉的这种症状？”他说没有。我说：“我晚上回去的时候我把药给你带回去（也是住的离我很近）”。我就想给自己一个回旋余地，我再想一想。到了下午，他又托他的一个同学来给我送了一个信说：中午睡完觉以后发觉脚有点凉。我说好——小青龙汤合上麻黄附子细辛汤，实际上就是小青龙汤加一点附子，但是辨证思路是这样，他有一点阴证了。另外，我知道他每天活动，我曾经问他：“你走得这么快，有跑的情况吗”？他说：“我不能跑，我跑几步我心脏就受不了”。这是我用的依据。小青龙汤合麻黄附子细辛汤给他以后，越吃越轻，慢慢就好了。也没吃多少天，这经方治病本来就很快。

还有一个是我们小区里边的警卫，他以前是武警，现在 60 多岁了，体格很壮，每天早晨坚持锻炼。他说平时喝酒，酒量很大，喝白酒半斤以上没有问题，经常喝酒。他平时饭量还特别大，比别人高一倍。我以前跟他聊天心里就这么想，像这种人如果要发病的话，肯定

离不开里热，因为他经常喝酒嘛！有一次也是晨练走到一块了，他跟我说：“我这一段老咳嗽”。我说：“你有感冒症状吗”？他说：“有点流鼻涕，别的没有”。我首先想到是麻杏石甘汤，就问他出汗吗？他说：“很少出汗，现在这段时间天热了有点出，但是没有正常人出汗多”。这就是有点偏于表实证，这样跟麻杏石甘汤又不太对路。我又问：“小便怎么样啊”？他说：“不太好！老是量也小，次数也多”。！我说：“咱现在锻炼着也不能摸脉，吃完饭上班走的时候，我顺便再给你看一下”。后来我就给他摸了脉，看了看舌。辨证如果一点资料没有，就凭着望诊，可以不带主观倾向，但是有了资料以后你肯定会有倾向了。我还是在找他到底是麻杏石甘汤，还是小青龙汤，后来一摸脉，脉偏迟、细弦、偏沉，就这一个脉就定死了，肯定是小青龙汤证了。我又看他舌淡暗、舌苔薄白，齐了。后来我就给他说：“我中午给你捎药回来”。我中午让他服了小青龙汤一次、大概不到 4 克的样子，后边就改成 2 克多，服了两天。第一天他服完了以后说：“中午吃了以后我出了些汗，还是有点咳嗽”。我说：“你感觉轻松点吗”？他说：“轻松多了”！后边就一直这么服，前后总共服了五六天就全好了。因为他年龄稍大一点，给他控制的药量小一些。

这三个病人虽然基本上是一个方证，但各有侧重啊。一个是腹部停饮为主的；一个是肺部停饮的，机能还偏于不足，小青龙汤合上麻黄附子细辛汤；另一个就是这个警卫啊，他既有表证又有停饮，各占一半，而且他没有躺下以后咳嗽得厉害这种倾向。

所以这就印证了条文里边列的那么多或然证，这一类的方剂，它表现的症状不是那么单纯，相对说比较复杂，面也比较宽，它有这样的特点，这个方剂中把它论述出来了。可是在理解这个条文的时候，那就不是这样了，方后加减就出现了很多的，一旦见到或然证就加减，一加减就要出问题。因为对方后加减的理解，直接可以反映你对经方理论理解的准确不准确的问题。

《伤寒论》和《金匱要略》都存在这样的问题：凡是条文里有或然证的方证条文，在方剂的后边都有相应的加减，跟条文里的或然证是一一对应的。作者的意思，出现某种或然证，就应该作相应的加减。只有理中丸这个方剂除外，因为理中丸这个条文里没有或然证，但是后边也有方后加减，等学到的时候我们再具体地分析。其他的条文都跟小青龙汤证的方后加减是相同性质的问题，尽管具体的药味不一样，加减的方法不一样，但是性质是相同的。小青龙汤条文是本书第一次出现方后加减，相同的问题我们还会放到后边适当的时候讲，比如小柴胡汤，我们在分析方后加减的时候再讲一部分。

第一个问题，关于方后加减我们应该怎么认识。小青龙汤从整体来看，方后加减纯属无中生有。它就是作者在没有弄懂经方理论的情况下所做的“添足”之笔。为什么呢？我们具体地分析一下：先说条文里列举的所有或然证都是小青龙汤的治疗范畴，小青龙汤本身就可以治疗这些证，特别那个小便不利这是最明显的，小青龙汤里这么多祛水的药，可以非常好地治疗因里虚寒造成的小便不利，或者说小便不利造成的停饮也可以。实际上原来作者的本意就是想说，因为这个方剂它治疗的是既有表证又有停饮，又偏于里虚寒。特别是停饮这个问题是怪证百出，所以在这里特意给举了几个例子，这些都是在临床当中积累起来的。上次已经说了，像这样的方剂这么多的或然证，绝对不是一时一世总结出来的，这得是在若干患者身上逐渐地积累起来的经验。比如这个患者有咳嗽，那个有小便不利，另外的甚至发了汗以后还会出现口渴，就这样一点一点地积累起来的。作者也考虑到了凡有停饮证往往症状都比较复杂，而且这个方剂在《伤寒论》里相对排的次序又比较靠前，它处在基础的位置上，所以在这儿就交代得比较清楚。但是它总的意思就是出现这些或然证，都是小青龙汤的主治之证。

另外一层意思是经方的加减。经方不是不讲究加减，而且经方的

加减出现频率还是相当高的，但经方的加减不是以这种方后加减的方式出现的。你看经方的加减：像桂枝加桂汤、桂枝去芍药汤，四逆加人参汤、四逆加茯苓汤、茯苓四逆汤，它不是以方后加减的形式出现的。而且还有一个很重要的问题：任何一个经方一旦加减之后，它的方剂的适应证就发生了很大的变化，比如桂枝加桂汤，没有加味，只是一味药变了剂量。所以说经方里所有的方剂都是非常严谨的，这是一套非常严谨的体系，而不是说经方的方剂不能加减，不是这个意思。它不是以方后加减的形式进行加减，从来不示范这么去作加减，而且条文本身也不是那个意思。

最后一个，方后加减好多看似有一些道理，但如果仔细地分析一下，每一个方后加减都有不合理的地方，跟经方理论接不了轨，这也能从侧面证明方后加减肯定不是出自经方原作者之手。而且从小青龙汤方后加减能看到，宋代的医书校正局的林亿他们看出了这一类的问题，后来加了一些暗语，也提出质疑。实际上历代都有质疑的，但总地说方后加减对后世的误导总是少数人，林亿他们的暗语就认识到了这一层，说这些或然证都是小青龙汤所主之证。但是到了小柴胡汤、四逆散、真武汤的时候，他又不这么认识了，这就是出专著的专家们太机械了，如果按他们的观点的话，林亿应该在每一个方后加减后面都应该写一个按语，他们觉得心里也就踏实了。咱们学习东西不应该这样，应该实事求是，我们应该学习胡老的精神。另外，既然我们把方后加减的性质给定下来了，方后加减尽管史料不多，但从蛛丝马迹里也能找到一些有用的依据。首先，《康平本》和《宋本》都有方后加减，《康平本》又早于《宋本》，所以说方后加减应该在《宋本》之前，理论上说它也应该在《康平本》之前，至少是和《康平本》同一个时期加上的。要是这样的话，据我们所知只有两个人：一个是张仲景，一个是王叔和。张仲景是得到了《汤液经》，后来又作了一些补充，形成了《伤寒论》；后来王叔和找到了这本书，后面大家都

知道了。这个内容肯定不会是《汤液经》的作者加的，只有张仲景和王叔和这两个人。用这种推理，再看看林亿他们的按语，《康平本》就没有，从这儿就能证明，《康平本》成书的时候，林亿他们还没有见到。

另外一种，我再跟大家罗列一下，《康平本》里“若渴者”成了“若渴”；《康平本》里“若喘者”在《宋本》里是“若喘”，没有“者”；还有一个小差别就是《康平本》里的“若噎者”，到了《宋本》里成了“若噎者”，这个就差了太多，不知道在哪个环节出错了，显然是抄错了。条文里就应该是噎，原稿如果模糊，容易抄错。

这个方后加减就是出自王叔和之手。理由就是《康平本》和《宋本》之间的方后加减就这么一点文字，出现了好几处的不同之处，仔细看看，明显是经过修改的，除了“噎”字之外，其他的明显都是经过修改的。只有王叔和有修改的可能性，因为通过两个版本的比较，我们发现凡是见到这个版本的人都非常慎重，甚至王叔和最初的时候，把原书的缺字都用方框给标记出来。古代抄写东西是往竹简上抄，一条竹简上几个字是有数的，漏字的情况非常少，所以这肯定是人为的修改的。特别像加杏仁半升后边又加了三个字，以前的书没有，这是特别明显的修改感觉。《康平本》以后凡是正规的版本，特别是《宋本》，宋代校正医书局校正的时候也特别严谨，他们也不会做这么大幅度的修改，只有一种可能性是王叔和改的，因为这本身就是王叔和自己写的，他在第二次整理的时候，他觉得改一下比较符合他的意思，会比较好一些。这也就印证了方后加减只能出自王叔和之手。方后加减本身从方向上、根本上错了，一是原文作者不是这个意思，另外那些或然症本身就是这个方剂能治的。

因为中药它有这样的特性：比如常见的发汗药像麻黄、桂枝，生姜也能发汗，甚至桑菊饮里的薄荷也能发汗，好多药性是比较接近的，但只是这一个点上接近。经方要这么加减了以后，方剂就不再是以前

的方子了，它的适应症也会相应的发生比较大的变化。所以说这种加减一个是方向上有了错误，另外一个就是当到了《宋本》的时候，它跟正文完全没有区别了，就对后世理解经方理论发生了非常严重的误导。而且越是看的有道理，它的误导就越深。咱们现在随症加减这是一个比较深刻的问题，咱们以后再讨论。这个方后加减对后世理解经方理论产生了极大的误导，我现在就常用这个来界定一个经方学者，有没有真正把经方理论弄懂弄通，这是一个分水岭。能够看清这些方后加减实质的，一般经方应用水平就比较高，理解得也比较准确。反之那就可想而知了。

我想从实际临床的角度谈一谈，再给大家加深一点印象。前两天我这有一个病人，60 岁左右的一个老太太，她主诉就是肠胃不好，心下痞，老觉得胃里不舒服，肠鸣，吃了东西以后老觉得肚子里咕噜咕噜的响，有时候下利，不是说老在下利。大家一听就知道差不多是一个半夏泻心汤证，比较明显了；同时还有脉迟涩，脉迟的严重，一分钟 50 多次；再一个是两脚怕冷，就在夏天她还觉得有点喜热不喜冷，精神不好，老想躺着；而且她还有一个特点，她是农村的，她来她姑娘这一天都待不了，她说我待这就觉得心里边支撑不了。因为她就是体质太弱，就是说心气不足，她觉得在自己家里环境也熟悉，心里也放松，想什么时候躺一躺就躺一躺，就是这样的一个人。我给她的方剂特别简单，半夏泻心汤合上四逆汤。看看这些药，换一种说法就等于说半夏泻心汤加附子，我在病历上写的却是半夏泻心汤合四逆汤。我们从这个医案试着分析一下，如果把它理解成半夏泻心汤加附子会是一个什么情况。要理解成是加附子，就具体到这个病人，就成了她的脉迟涩，脚恶寒，精神不好等等的都是附子证了，这成了附子主证了。如果按照半夏泻心汤合上四逆汤这种理念去理解，半夏泻心汤证还可以出得多一些，比如出现想呕吐也可以。这里还有一个事，她还有寒热错杂的情况，她脉跳的那么迟，她自己说我有点上火，牙

跟还有点肿，这不是寒热错杂吗？特别符合半夏泻心汤证；同时她还可能出现更多的四逆汤证。所以说我们在辨证过程当中，我碰到的这个病人，她具体就这几个证，她再有四逆汤的其他的证可不可以？完全可以。你要理解成半夏泻心汤加附子的话，就等于所有的四逆汤证都成了附子证了。这就是理论上差之毫厘，临床当中就谬之万里。要那样的话，你在临床辨证过程当中，附子动不动就用啊，还是不知道该怎么去合四逆汤啊，这种情况都会出现的。要如果在别的方证里边再出来，比如小柴胡汤又有嗜卧，你看见嗜卧这不是附子证嘛！你用小柴胡汤加附子，就没有道理了，那本身就是小柴胡汤治疗的范畴，没必要加附子的。如果这样推下去以后，大家会发现，一开始的时候看着还模棱两可，但是跟临床去接轨，就会发现这是一个很严重的问题，是一个原则问题。

另外，前两天我听到一种很普遍的说法。说经方也是由一味药一味药的这么罗列起来的，都是单味药相加，甚至经方里边有好几个方子就一味药嘛，像甘草汤，一味瓜蒂散啊。说这种观点的人，貌似特别睿智，特别有见地，而且还特别有气魄，大有他这一生足以和张仲景抗衡的这么一种气魄。但是这种观点对我们应用经方很不利。首先经方里的每一个方剂，都是经过长期的临床实践确定下来的最佳组合。这个没有必要多说了，有的用现代医学的方法来研究经方，做了好多试验，到最后惊讶地发现，在两三千年以前中国古人搞的那些方子，它治疗相应的适应症的时候，只有它原配比组合疗效最好。实际上这本身就说明，它是经过了长期的临床实践，最终确定的一个最佳组合方案；另外，整体地看一看经方里所有的方剂，每一个方剂都是在长期的临床实践中筛选出来的最佳方剂；还有一个方面，就是经方里的每一个方剂，都对应着一种人体的典型病理状态。仔细分析一下就行，除了它举的个别的例子以外，包括它一些很偏僻的方子，那肯定是出现的那种证少，但是一旦碰到那种病人，你离了那个方子就解

决不了。

我们从另一个角度说，随证加减也是在不断的积累中，随证加减跟经方走的是两条路。在经方之前早就有随证加减的积累，不然王叔和不会搞了这么成熟的一套方后加减。这就是说，方后加减在王叔和之前若干年，甚至几百年、上千年早就有这样的一个医学派别，甚至它就是中医的一个主流，一直在积累，到现在始终没中断过积累，现在市面上的中医们大部分都在走这条路，而且积累的方剂成熟的也很多。《方剂大词典》里有一万五千八百多个方子，但这些方子却不足以和仅仅只有两百多个方子的经方抗衡，它没法相比。不是说那些方子不治病，也治病，它积累了这么长的时间，这么多人去积累，甚至后来派生出了很多的派别，像温病派、火神派、脾胃派啊等等。但没有哪一个派别超过经方的。这些随证加减积累起来的方子，从整体上离经方的境界差很远，而且很难找到有成熟的定型的方子，可以和经方里的单个方子相比。比如小柴胡汤，你很难找到一个能治类似病的时方，疗效和小柴胡汤不要说相接近，能有个差不多，有这样的方子那就不简单了。

所以，中医里很多这样的东西，要是初看感觉这个观点特别好，特别有价值，但要仔细地去分析分析就会发现有差距。具体到这个问题我们没必要舍近求远。古人已经给我们找到了最近的路，最合理的方剂组合，你再绕开它干嘛呢？无非就是下一点功夫把它学会了，学会了怎么用不就行了嘛！就是说没必要去舍近求远，应该下功夫把经方的理论学好。

再反过来看，那些随证加减积累的方子也都是一些好方子，也治病，用对了有些方子也是非常好的，也很有价值。如果能在弄通了经方理论的基础上再去看、去用这些方剂，那就会如虎添翼。我们看看胡老这一生的实践，就是说你要是能把经方学好了，你完全可以去做更深的探索，不做你也是一个了不起的医生。关于方后加减就说这么

多，等以后再碰到这类条文我们再深入地讨论。

小青龙汤里还有一味药，就是细辛。为什么在这儿提出细辛来啊？细辛的临床应用中，据统计资料看，应用细辛的量最大的记录是40克，一剂药里边40克，而且患者服了以后没有任何的不良反应。在统计资料里有这么一个医案，医生给一个患者开的小青龙汤里边有9克的细辛，吃了以后出现了呼吸困难，然后到医院经过抢救才脱了险。这就有一个问题，我们不能轻易地说细辛临床中大量用绝对没问题，但是更不能轻易地细辛不过钱，用这个给束缚住，你真的不敢用，应该还是小心一点好，因为实际临床中确实有这样的医案。如果讨论，我们不妨换一换角度思考一下，为什么会出现这种问题？有的人喝40克没问题（还有人写过一本书，书名叫《细辛的临床应用》，作者曾经用水煮60克细辛喝了没事，比这个量还要大），但是临床中又确确实实有不到10克就出问题了。所以历史上这个“细辛不过钱”也不是空穴来风。但是这个结论下得过于粗浅。

按现代医学的解释，应该有的人对细辛这种东西过敏。咱们今天不应该讨论过敏的，过敏本身实际上就是一种病，治好了它就不过敏了。现代医学不知道过敏的原因是什么，如果遇到什么东西过敏了，它就让你离开这个东西，千万不要去接触它，实际上这都是被动的，把它治好了就不过敏了。所谓的过敏体质是因为治不了的病，给人家扣的帽子。这个地方就是说之所以用一点细辛就受不了了，是因为对细辛过敏，按现代医学和说法，这样好理解。为什么过敏呢？肯定在临床中有某些小青龙汤证之外的特殊症状反应，或者说是对小青龙汤证的某种反应比较强烈吧，但是现在还没有人能够积累这样的经验。历史上就有人武断地说“辛不过钱”，不能大量用，大量用就坏了。现在临床实践中看有的人确实不能多用，但是大部分人多用了没问题，至少用经方的原量是没有问题的。我们应该去想这个问题，为什么？我的观点就是有的人过敏，他必定在临床中有相应的症状反应，

肯定有特殊的证，但是我们还没有真正找到根源。临床当中可以去注意一下，总有一天能找到细辛使用的规律。

大阳病、外证未解、脉浮弱者、当以汗解、宜桂枝汤、

(42)

胡希恕：他说太阳病外证未解，外证其实就是表证了，他这为什么搁个未解呢？这就说明这个太阳病啊，依法服完麻黄汤，如果这个表还没解，脉浮弱者还应该以汗解，宜桂枝汤。这个外证和表证是两码事，在他这个书上，这个表证啊只是不得汗出，在体表那里呢。麻黄汤的表不解常说表不解，这个桂枝汤呢，咱们头前讲的桂枝汤，本为解肌呀，它这个病在肌肉这一层，他比表深，可也在人体的外，体表、体外，所以他叫外证，桂枝汤证他常叫外证，他与表证作一个区别。

所以这一段就是这样，太阳病它外证还没解，表是解了，就是吃完麻黄汤，太阳病还没解，这就叫做“外未解”。这个“脉浮弱者”，脉拿手一诊呐，虽然浮，这个脉往外，但是一按呢，不禁按。“弱”，缓的意思差不多，就是浮于外弱于内的这种脉。这个还应该以汗解，应该“宜桂枝汤”。这个桂枝汤的应用啊，主要是津液有所丧失，再用桂枝汤，不然的话应该用麻黄汤。那么桂枝汤这个方剂，我们头前有个桂枝加葛根了，所以当大夫不能守方治病啊，他要是与桂枝汤证有些出入呢，就要加减了，他底下就说的是一个加味方。

李冠杰：原文：“太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解，宜桂枝汤”，《康平本》就到此为止了，《宋本》在这个条文的后边还有桂枝汤和桂枝汤方后注，在《宋本》里边像这一类的情况很多。这说明什么呀？到了宋代的时候可以付诸印刷了，可以批量的出书，所以对字的多少就不太在意了，跟我们今天在电脑里打字，对字的多少

无所谓，有的是空间，顶多是费点时间，跟这个道理很相似。为了方便把桂枝汤等好多方剂都出现了一些重复，在《康平本》里头是没有的。所以说我们看《康平本》能够看到《伤寒论》的古貌，因为古人在竹简上写字，他是能省一个字就省一个字，《康平本》里边方剂绝对没有重复。这个条文在《康平本》里边是一个顶格排版的条文。

下面解读一下：

这儿的“太阳病”，我们就简单地把它理解成整个的太阳病而言，包括表实证，也包括表虚证。它总的意思是说人体停留在太阳病的病理状态，还在这个阶段，还是表证。在后边的条文里边的太阳病，只是说人体患病以后表现的外貌看似像太阳病，这是后话。

“外证未解”，应该做两层理解：一层是它本身隐含着服了发汗药以后表证没有解；另外一层是尽管是表证没解，但也没有发生其他的证，“外证未解”嘛，也没有发生其他的一些疾病，没有发展成阳明病、少阳病。不能仅仅理解成这个病还在那儿，古人常常是这样，他不会轻易地说“外证未解”，为什么未解呀？因为服了药以后未解。

“脉浮弱”，跟浮缓的脉比较相似，严格地说或许更弱一点。如果太阳病出现了这种脉象，从机理上就是津液不足了，跟前边这些佐证，“外证未解”，已经含有了发汗以后津液不足了。

“当以汗解”，在这个地方一再强调，实际上不仅仅这个地方，也就是说表证的治疗原则就是发汗，“当以汗解”嘛。深想一下，这儿有另外的一层意思，即使是经过治疗之后表证没有痊愈的，而且没发生其他疾病，原则上还是要发汗，但是方剂不一样了。前边可能服过桂枝汤，也可能服过麻黄汤，只要是表还没有解，脉还有浮弱的，就应该用桂枝汤来治疗。

但是要考虑病随时都有可能发生其他的变证，所以这儿给你一个“宜桂枝汤”，有斟酌的余地，自己去斟酌，如果有其他的证还要涉及到其他的方子。

这个条文的重点在哪儿？他论述的方剂也不是什么新鲜的方剂，应用其实在别的地方有近似的讨论，这个条文重点在强调，一个是发汗是太阳病的治疗原则，到什么时候也不能离了这个原则。再一个它进一步的具体说明，太阳病或者发汗或者经过其他的治疗以后，人体仍然停留在表证阶段的，都要用桂枝汤来治，用麻黄汤的机会比较少。

下边做个小结：太阳病服发汗药或以其他方法治疗后表证未解除，若未发现其他类型疾病，并出现脉浮弱的，仍以发汗的方法治疗，适宜桂枝汤。

大阳病、下之微喘者、表未解故也、桂枝加厚朴杏子汤主之、（43）

桂枝三两去皮 甘草二两炙 生姜三两切 芍药三两 大枣十二枚擘 厚朴二两炙去皮 杏仁五十枚去皮尖

右七味、以水七升、微火煮取三升、去滓、温服一升、覆取微似汗、

胡希恕：太阳病不应该吃泻药，那么这个大夫啊，误用下法，那么这个病人是“微喘者”，这个喘啊，我们头前有这么一段啊，“太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，如前法”。这个喘也是气上冲的一种反映，这个气往上冲，表未解，这个邪热也伴着往上冲啊，所以他也喘。微喘，不是咱们说的哮喘那个喘，这个微喘也是气上冲的一种表现，所以还用桂枝汤，还是表不解，那么依法应该用桂枝汤，但是由于微喘，与桂枝汤证多少有出入，所以加厚朴、杏仁消胀定喘。这就是所说这个治病，你就用桂枝汤行不行，这个也对，也不能坏，但是他喘未必然就好，而且这个效验啊也绝不如桂枝汤再加厚朴、杏仁。所以我们在临床上啊，这个病不恰好这个方子，他有些与这个方

证有所出入，你就得想法子，这个也是这样的。头前有那么一段我记得，“喘家，作桂枝汤，加厚朴、杏子佳”，也是一样。这个人平常就有喘，再得外感，这个喘非厉害不可，他是桂枝汤证，那么桂枝汤证呢也要加厚朴、杏仁才好呢，同这一样，所以这个厚朴、杏仁呀有消胀定喘的作用，在这看得很清楚。那么桂枝汤加上厚朴、杏仁，我们现在应该这么来看，就是桂枝汤证微喘者，可以治这个病，但是无汗而喘不行的，那还是麻黄汤证，是不是？

李冠杰：这一条在《康平本》里边也是顶格的条文。

下面我们解读一下：

这个“太阳病”，跟前面的太阳病实际上是一个意思。人体患的就是阳性表证。

“下之微喘”，这个“下之微喘”，是太阳病误治以后，出现的若干不良后果的其中之一。事实上，我们要是整体解读经方理论的话，你会发现太阳病，不仅仅是太阳病，误治以后可能出现若干个后果。因为人体的不同，误治的方法不同，可能会出现很多不良的后果。甚至有的误治以后病还能好了，第 58 条就是这种情况。这个地方讨论的是其中的一种，比较典型的一种。表证误用下法以后，也没有发展成其他类型的疾病，但是在表证的同时，又出现了喘的问题。

这个“喘”在这儿，在病理上至少有三个方面的因素可以造成：一个是表证存在，或虚或实，这个时候往往影响到呼吸系统，就算是表虚证，实际上呼吸功能也会受到影响，表实证当然影响的要大一些了；再一个就是误下之后，人体就虚了，条文里边明明白白写着的；下一个更重要的因素是人体平时的呼吸系统就比较虚弱。这些因素加到一块儿，就促成了他会出现喘的这种情况。

再想一想，第 18 条不就是“喘家作”嘛，那个地方写得很明白了。本来就有喘，如果再出现表虚证，就可以用桂枝加厚朴杏子汤。这个地方是误下了以后，表证仍然存在的，一般要用桂枝汤来治。但

是喘，不是桂枝汤能治得了的，就得在桂枝汤的基础上再加上厚朴、杏仁。你看，经方的加减是用这种方式来论述的，而不是用方后加减的那种方式来论述的。

做个小结：太阳病，如果误以泻下的方法治疗后，造成微喘的，若患者仍在表证的病理阶段，则为桂枝加厚朴杏子汤主治之证。

我们通过学习这一条，做一个简单的延伸。经方理论重证不重病因。你看这个地方，有这个病因也好，没有这个病因也好，就是说有误下也好，没有误下也好，以前他有点喘的，就是喘家，也得用这个方剂来治。再比如说，如果是发汗不得法，还现表证，有咳喘的话，也得用桂枝加厚朴杏子汤。所以说经方重的是方证而不是病因。

大阳病、外证未解、不可下、下之为逆·欲解外者、宜桂枝汤、（44）

胡希恕：这个他把外证啊特别提出来了。他说本来是太阳病，如果外证没解，就是指桂枝汤证了，那是万不可下的。头前有一个桂枝汤证，医反下之，所以利遂不止，不有那么一节吗。那么这个给桂枝汤作总结，把前后都说了。太阳病，桂枝汤证还存在，所以叫“外证未解”。凡是有这种情况，外证未解的情况，就不可吃泻药。“下之为逆”，如果要给吃泻药，这就是治疗的逆治，这是错误的。那么外证怎么治呢？那就宜桂枝汤，外证就指桂枝汤证说的。

李冠杰：这条也是一个顶格的条文。但是这个旁注“下之为逆”，实在是没有意思，咱们到最后再简单地说两句。

这“太阳病”，咱就不说了，就是阳性的表证。

“外证未解”，跟刚才学的条文里有点相似，它也隐含有经过治

疗，表证仍然不解的意思。再一个是在强调人体仍然停留在表证的病理阶段，并且没有其他疾病的存在，这是必须理解的。

“不可下”，实际上是在强调一个治疗原则。表证在任何情况下都不可下，在这儿就是强调不可下。

“欲解外者”，要想解表，还得用桂枝汤。用桂枝汤从条文里就明显地能看出来，前边用的是“太阳病”，里边没有任何症状，在后边给了一个方剂，这个方剂的依据就在于“外证未解”。“外证未解”本身就包含经过治疗了，下也好，发汗也好，它还停留在表证阶段，就应该用桂枝汤，而不能再用麻黄汤了。

“下之为逆”是旁注。类似这样的注解，我们看着都会觉得多余，人家前边有已经说了不可下，不可下就是不能下嘛！下了的言外之意不就是错吗？从这个地方我们能感悟到旁注的作者说得直接一点，这人就比较浮浅，生怕别人不明白，絮絮叨叨地说一些没用的话。

这一条做个小结：太阳病，虽经治疗，但是表证仍未解除，并且没有发生其他类型的疾病，此时切不可使用泻下的方法治疗，解表宜用桂枝汤。

太阳病先发汗不解、而复下之、脉浮者不愈、浮为在外、而反下之、故令不愈、今脉浮故在外、当须解外则愈、宜桂枝汤、（45）

胡希恕：中医有这么一个说法：汗下，发汗不好了，完了吃泻药，这是一个陋习呀，这是不对的，庸俗陋习。那么这一段就说明这个，“太阳病，先发汗”，应该先发汗，就是用麻黄汤发汗，这个病没好，这不是错误啊，真正的重感冒也是一样，你像我们遇到流感，你给他吃发汗药，由于这个病重啊，他不是一下子就能好的。没好了，这个大夫应该看只所以没好的原因，到底根据现在证应该用什么药。这个

大夫粗心，他一看发汗不好，“而复下之”，那发汗不好，我再给吃泻药吧，这是有这么一种大夫，但是不是人人都这样子了。“脉浮者不愈”，你吃泻药的时候看看脉呀，脉还浮，外不解，那应该吃桂枝汤就对了，所以先发汗不解，那就是外不解，应该吃桂枝汤。这个大夫没这么来，他（给）吃泻药了，吃泻药的时候，脉浮者不愈，根本就脉浮，外不解，吃泻药是误治，这个病是不会好的。什么道理呢？底下他解释了，“浮为在外，而反下之，故令不愈”，根本这个病还在外嘛，到里边治去了，吃泻药不是治里吗，所以这个病它不好。那么现在发汗了，又泻了，这阵儿再看看这个脉呢，还浮，所以这个病仍然在外。那么在外，你就“当须解外”就好了嘛，给他吃桂枝汤就行了。这里头你们看出来没有，桂枝汤证与麻黄汤证用药有个定法，发汗后，下之后，这个表不解，太阳病不解，不能再用麻黄汤，都要用桂枝汤。

桂枝汤可见是最平稳不过的药了。就是用了桂枝汤，表还没解，还要用桂枝汤，不能用麻黄汤，这是定法，这个在临床上挺重要。就是我们给人家发过汗了，用麻黄汤，然后你再用银翘散也不行，这个薄荷还是发汗的，所以必须用桂枝汤。这是外不解，不是表不解了，已经发汗了，透表出汗了，所以这个地方挺重要。这我们就看出来中医对这个外表呀，外表就是咱们普通得了感冒，这里头不是随便，现在咱们讲立个法吧，就是辛温发汗吧，我们讲这些都是辛温发汗，应该用哪个方剂呀？他提出桂枝汤证、桂枝证，就是要辨方证，原则上应该用辛温发汗，它是太阳表证嘛，所以是各个不同。我们还没讲完，这太阳篇还早呢，因发汗就是这么样子复杂。应该用葛根汤的，你要用了桂枝汤是绝对不行的，用麻黄汤也绝对不行，不但无效，而反有害。所以这个方剂搞不清楚，不能治病，我们看这个书也看出来了。这个书上方子本来不多，非要记熟不可，不但要记他的药味、分量，而且还要知道这个方剂适应的一切，你这样才能治病。究其实这个很

好明白，又好学，不是难学，你记住这个就能治病啊，记不住不行，你光谈论这些理论不行，我们看到这儿就看出来了，你看这个解表方剂，你看这几个都不一样。你看大青龙汤那个，很像麻黄汤证，那个证候你要用麻黄汤是绝对不行的，不但后面说这个“伤寒，脉浮缓，身重，乍有轻时”，那个根本就是个水气病了，那用麻黄汤就更不行了。就是他说那个中风，他特意搁个中风，怕你用麻黄，他那段那个语句很好啊，所以后世注家，他越好越给人走邪路，说又治风又治寒，他给这么看了，风伤卫，寒伤营，大青龙汤就治营卫两伤，哪有这些事呀，不是的，他这个文章都有用意的，他在这特殊加重，引起你注意，这个不是麻黄汤证，可是有麻黄汤证，同时有越婢汤证，他就是这个，你要分析这个方剂，就能明白这个，你要不分析方剂，你就不清楚。

李冠杰：本条在《康平本》里边是降两字格排版的条文。一般的我们认为出自王叔和之手，而且这个条文可以说是王叔和的一个代表作，不是正面的代表作，是负面的代表作。

为了更好说明问题，我们先作一个直译：

太阳病先以发汗的方法治疗没能治愈，反而又用泻下的方法治疗，如果脉浮的说明病仍没有痊愈，因脉浮为病在表，反而误用泻下的方法治疗，所以使病不得愈，此时如果仍现脉浮，说明病仍在表证阶段，还应该以解表的方法治疗即可痊愈，宜用桂枝汤治疗。

大家听听，我作这个直译尽可能地把原文用咱们今天的话说出来，还尽可能地不给他作延伸，所以我把它叫做直译，而没把它叫做小结。大家听的过程可能就有这种感觉，反复颠倒、絮絮叨叨很不简洁。我们应该怎么理解这个条文呢？这个条文其实是对第 44 条进一步的一个解释。

第 44 条说的是表证发汗后不解就不可以用泻下的方法了，应该用桂枝汤治疗。这个条文它有了一点延伸，表证发汗以后又使用了泻

下的方法，但是仍然停留在表证的病理阶段，也还得用桂枝汤。他又明确了一层，还没有用泻下的时候强调千万不要用泻下的方法，这个地方说的是又给泻下了病依然没好，还要用这个，好像有这么一点延伸。你要这么一看，好像是人家也不是在这说胡话，这不也是强调的一个问题吗？实际上经方其他的条文已经把这个内容说了，第 15 条“太阳病下之后，其气上冲者，可与桂枝汤”，而且大家看，特别是顶格排版的条文，全部都是这样，它在别的地方说了在这儿就不用说了，因为你知道了。所以说写这个条文，实际的意义不是特别大，但是他写在这个地方，我们就跟他打一下圆场吧，发完汗以后再用泻下的，一看病不好再用泻下的方法治疗，这在当时可能是一种比较流行的陋习，他在强调这个问题也未尝不可。但是你再看看文风就没法给他打圆场了，像我们都有点这种想法，写这个东西的时候自己不嫌麻烦吗？要让张仲景写的话，恐怕这个条文里面只能剩下三分之一的字。说这个好像对古人有点苛刻了，但是没办法回避这个问题，王叔和这个人确实就是务虚的那种倾向比较严重。

接下来跟大家交流一个医案。我感觉这个医案有点意思吧，或许能从中得一点点启示。这两个病人是母女两个人，最早来看病的母亲，当时医院里面给她检查的结论是食道平滑肌肌瘤，当时拍有彩超，医院说得做手术，没有别的办法。

这个老太太胆小，一说是做手术，特别是在食道里面，她不敢做，恰好是春节走亲戚的时候聊起来这个病，她这个亲戚就把她带到我这儿来了。我当时看的时候，那是一大堆的症状，我先跟大家说我给她用的方子吧：有栀子豉汤、半夏泻心汤、半夏厚朴汤，还有桂枝茯苓丸四个方子合到一块儿，四种证都有，像吃了东西以后食道里头不舒服，热辣辣的，噎，她食道里头有瘤子肯定会噎的；再一个就是肠鸣，大便不好；咽喉部分老觉得有东西，老想往下咽，吃了这个方子后感觉轻多了，后来逐渐地什么症状没了，就给她去掉什么方子，前后吃

了两个月，她给我打电话说我现在觉得很舒服，自己感觉没有什么不舒服了，我说你去医院拍片，结果她到医院里边去拍片，一个县城里边本身就不大，那个给她拍片的，还是第一次拍片的那个大夫，看了片子以后感觉非常惊讶，瘤子没有了。他就跟她说，你这是怎么弄的？这个地方，一般的药那个劲使不到这个地方，瘤子怎么没了呢？他就觉得非常惊讶。她说这两个月里边，不仅仅以前那一大堆的症状全部消失了，而且她脸上的色斑，六七十岁的人了，基本上都退得当时都看不太出来，脸色非常光泽，判若两人了跟她当初来看病的时候。

前两天这老太太的姑娘来看病，四十多岁了，和她母亲的病有点相似，感觉吃东西的时候嗓子里边不舒服，平时也老觉嗓子里边有东西，就是咱们《金匱要略》里边说的，“咽中如有炙脔，吐之不出，咽之不下”，就是那种感觉。医院里边去检查也没给她查出什么病，我说吃点药吧，用不着多少天就能好，她有明显的半夏厚朴汤证，再一个她暖气，感觉背有点沉，我一再问她是不是胃里边有什么不舒服，她说没有什么明显的不舒服。我就告诉她你这个病在胃里边，她也将信将疑，弄了药以后回去吃了一天，第二天给我打电话。她说药吃了，可能有点作用吧，但是她觉得不是特别得快，因为她一家人都在我这吃药，都知道我这药下去以后，一两天就能见效。过了一天又给我打了电话来了，她说老是觉得不放心，我到医院里边又去检查，又去拍了个片，医院给她的结论是咽炎和胃炎，她说还真让你说着了，我真是胃里的毛病。后来她给我说，我特意给你打电话就是让你不要再挂着了，我感觉服了药以后还是挺有效的。

大家应该在这儿注意，病人常常都有一个相当重要的心理作用在里边，特别是现在，面临着医院和中医的这个选择，你再好的中医，反正就一个人在这坐着，两只手一张嘴一个笔，她就觉得不如在医院里边来得更可靠，又是动用一些仪器什么的，特别是心理上比较敏感的一些病人，有时候会有一些心理因素掺杂着，临床当中这也是我们

应该注意的一个方面，你预料到这个问题以后，就提前解释得周到一些，可能会避免出现类似的一些问题。像这个病人，这真要按照相信程度来说，那这是特别信，最起码在我这儿她一家人都在这儿吃药，老的小的都在这儿吃药，但是她还能出现这种情况，心理因素还是挺重要。

大阳病、脉浮紧无汗、发热身疼痛、八九日不解、表证仍在、（注）此当发其汗·服药已微除也·（经）其人发烦、目瞑、剧者必衄、衄乃愈·所以然者、阳气重故也、麻黄汤主之、（46）

胡希恕：这一段啊，它就是这个表证，就是麻黄汤证，也有多日不解的。头前刚刚有一个，“太阳病，十余日，脉浮细而嗜卧者，外已解也”。一般说呀，它要是这个病由表传里，或者是传半表半里，这个八九天，大概都传里的多，可也有例外，这条讲的就是的，本来就是脉浮紧，无汗发热身疼痛，这是太阳伤寒表实证啊，脉浮紧，发热无汗身疼痛，那么如果经过八九天，一系列的证候啊不解，经过我们审察呢，表证仍在，他这个“表证仍在”不是一个废话，他里头啊虽然说是脉浮紧，发热无汗身疼痛，是个表实证，但没有恶寒，你看这里头，那么必须恶寒才是表证完全没解呢，他里头搁个“表证仍在”，他就是言外有因啊，说经过详细审察确认是太阳表证，就是麻黄汤证了，而仍然存在的话，那么这样子呢你不必顾虑日数多少，仍然可以发汗。那么在这一句话后头啊就是麻黄汤主之，这麻黄汤就吃在这个时候。

那么吃过这个药之后，“服汤已”嘛，“微除”，这个病一时地感觉轻快，所以比较好啊，有效，但是同时呢，可是这个人就发生“目瞑、发烦”，发烦就是发烦热呀，烦躁不安而闭着眼睛，死不瞑目啊说死了都闭不上眼睛，这个他当时就是闭眼睛。那么这是什么呢？这

个病比较重，时间久，或者是经过误治人身体虚，那么这个要是吃药中病，常常地发生意想不到的瞑眩状态，这就是瞑眩。古人有一句话呀，说“若药不瞑眩，厥疾不瘳”，这是《尚书》里的一句话。说假若吃药之后，没有这个瞑眩的反应，这个药好不了他的病，这是古时候有这么一句话，可是这临床上经常见到、遭遇的，那当时很吓人的，你看这个人吧，睁不开眼，闭着眼睛发烦躁，折腾不安，这个就像这个药啊不对头似的，其实这个病是必好。“剧者必衄”，他就说的瞑眩的这种情况，要如果再厉害的话，鼻子也要出血，但是这个呀不必害怕的，“衄乃解”，鼻子出血，这个病就要好了，那么言外就是不出血，就是发烦目瞑，这种瞑眩状态发作，这在临床上这个病非好不可，这个咱们在临床上也是常遇到的事情。但是一般的疾病它要不是日子久，你看这个他是八九天啊，八九天应该汗出而不汗出，那么他有这种情况反应，再不然人身体素虚，得一种急性病，那么他要发生咱们说这个战汗等等的，有的是，后面咱们这书里头也有的是，那么他没明说，这个也就是瞑眩状态，就是吃药中病，一种有验的反应，就是这个药有效验的一种反应，这个事情常遭遇的。

我也遇到过这个事情，半夜让人去砸门去，也就是这么个事，我给他吃本来是治下利的一种药，他吃完了是下利无度。半夜砸我们门去问，这种情况，我说不要紧，我说你回去吧，我说再连下吃就好了，这个药治下利的，它不会更下利，不过来这个人他说不行，您非看看去不可，这个人厉害得很。后来我就去了嘛，正是半夜，去了这个小孩子就好多了，是个小孩。后来我说把二煎再吃了吧，他妈还不敢（让）吃，我说不要紧，吃了吧，吃完了第二天就好了。这个事情很容易遭遇的，有些方剂，也不是个个方剂有这个情形。这个麻黄汤啊，如果是人体虚，病久，常发生这种情况，何以呢？底下那个所以然，为什么这个人他要这个样子呢？要有这个瞑眩状态呢？所以这种这个体液啊充斥周身，脉也充血，所以脉紧嘛。这个说明邪重，日久不好，

他要发眩晕，所以出血也是这种原因。他这个外边这个浅在动脉充血达到一个高度，鼻子这个地方最容易破，所以要出血的。这个阳气呀，古人这个阳气，不一定就指的有热，后世不就都搁上热了，不对的。他是认为这个气分和血分分成阴阳的，凡是气分，体液也是属于气分的，古人说这个气就是指的津液，这个我们讲到后头我们再说，那么这个不是热，就是由于这个太阳病，咱们开始讲了，就是人患病这个机体啊，太阳病它这个发作呀，就是想用体表达达到发汗的目的而解除疾病这么一种病理状态，咱们开始讲了。那么老也达不到汗出，到八九天了，这个体液充斥体表是越来越重，越重他越发不出汗来，越不能出汗，那么这个时候一汗出的时候，咱们给他用药帮着了，由于这么样子阳气重，他要发生眩晕而衄血的，他这个解释就是如此。咱们可见这个古人说的阳气就指的精气，精气指的什么呢？就是血液、津液，脉外的津液，脉内的血液，都叫做精气，就是养人的精气啊，以前咱们讲过了，至于这种他叫做阳气。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边是顶格排版的条文。

这个条文里边呢，既有嵌注内容，又有旁注内容。《康平本》里边，嵌注的内容前边都有一个小圈，圈里面是一个“注”字；在嵌注的最后是一个方框，方框里面是一个“经”字。这个“经”字是一个承启字，这个后面是《汤液经》的内容。本意呢应该是这样。张仲景是论广《汤液》嘛，是在《汤液经》的基础上写出来的。所以说这个“经”字后边，就是提示读者那是《汤液经》的内容。在《康平本》大概就是这个样子。

这个条文里面呢，《康平本》和《宋本》多少有一点点差异。“服药已微除也”，《宋本》上没有这个“也”字。那个旁注呢，“衄乃愈”，《宋本》是“衄乃解”，这个没有什么原则的区别。

下边解读一下：

这一条也冠以“太阳病”。“太阳病”在这一条里边，指的表实

证。

“脉浮紧、无汗、发热身疼痛”，这全都是阳性表实证的典型的症状反应。

“八九日不解、表证仍在”，这一句话有非常重要的意义。在经方理论里面，人体患病以后，特别是患表证以后，一般的规律呢，到四五日左右经常会发生变化。或是发展成少阳病，或者发展成阳明病，甚至是发展成阴证，都有可能，当然也不排除有自愈的。但是这个地方所讨论的，恰恰是很特殊的情况。一个阳性表实证，没有按着那个规律发展。已经过了八九日了，疾病没有发生质的变化，仍然维持在表实证的病理状态。为什么会表现出这么一种特殊的情况，而不是按着正常的规律发展呢？原因实际上也非常简单。就是致病因素比较强，人体抗病的抵抗能力恰恰也不弱，能和致病因子进行抗衡，使这种病态维持好长时间。“表证仍在”，暗含经过治疗表不解的意思。

嵌注“此当发汗、服药已微除”，也许嵌注的作者遇到过这类情况，这是他临床经验的一个总结。表实证比较重，或者比较长的时间了，给他吃发汗药，症状稍微去一点，但是疾病却没有发生本质的变化，就是这么一种情况。这个嵌注还是有临床价值的。

下边咱们再往下看，由于表实证多日不愈，人体就出现了很多太阳表实证之外的一些症状。但是这儿有个前提条件啊，肯定是在太阳表实证的基础上，又出现了这样的症状。什么样的症状呢？“发烦（发作烦躁）”、“目瞑（眼睛闭着不欲睁，就说连眼睛都不愿意睁）”。实际上就是说病的时间长了，这也是人体抗病的一种冥眩状态。

严重了，还有可能出现“鼻衄”。这个“衄”字，广义地讲，指的是五官皮肤出血；狭义地讲，就是指的鼻腔出血、鼻衄。这一条里边，指的应该就是狭义的意思。

后边有好几个条文，提到了鼻衄。那么鼻衄的机理，从这一条里面看得是比较清楚的。一方面表实证比较严重；另一方面，人体又表

现作为一种极度的亢奋状态。其实前面这些症状，像“发烦目瞑”，也是一种亢奋比较严重的症状。我们学习这个条文，就应该理解到这一层。

前边这些症状看似阳明病，包括目瞑再加上一个衄血，好像都不太像表实证的基本特征，你不要当做阳明病来看。因为在表实证的这个阶段，人体表现得过于亢奋，里面大量的体液不断向体表输送，外边又不得汗出，这样浅表血管里边的水分含量越来越高。这个时候，特别是鼻腔里边鼻粘膜浅表的血管，比较娇嫩，就容易造成破裂出血。实际上就是这么一个过程。后边有“麻黄汤主之”。

所有这些，他也做了一个解释，“阳气重故也”。所谓这个“阳气重”，有体液过剩这方面的因素，同时也有人体抵抗力比较强盛这么一层意思。在这儿就是说，在表实证得了多日以后，表仍不解，如果出现这一类的症状的话，不要当做其他类型的疾病，这就是表实证的一些极端的反应。

这儿有一个旁注，“衄乃愈”。这三个字纯属误导，不仅仅是可有可无的问题。这个作者太过肤浅，后面的条文有几处论到了衄血的情况，有一条就说到衄血以后表证就可以痊愈了，他实际上是从那个地方过来的。但是他就不去想想，还有其他的条文论述衄血以后，如果还不好的话，还要用麻黄汤来治。他不能整体地来看，恐怕临床当中他见到过衄血以后好的，就在这儿加了一个小说明。但是这个说明绝对是不应该加的。“衄乃愈”，病已经好了，何来“麻黄汤主之”？有衄了，不好的，后边条文里边有。这一类的注解就不是画蛇添足的问题了，就是说态度不严谨、片面。临床当中确实有，条文里边也有，出现鼻衄以后，痊愈的，他就强调这一方面。但是这个条文里边论述的不是那个情况，论述的是出现了上边这些反应以后，表证并没有好。没有好怎么办呢？还得用麻黄汤来发汗，就是这个意思。

咱们对这一条做个小结：太阳病，症状表现为脉浮紧、无汗，发

热身痛，已经过八九日的时间，虽经治疗但是疾病仍然停留在表实证的阶段，并且患者又出现烦躁目瞑，甚至鼻衄等新的症状反应，这是由于致病因素和人体抵抗力都较强的缘故，仍为麻黄汤主治之证。

大阳病、脉浮紧、发热、身无汗、自衄者愈、（47）

胡希恕：他说也有这个情形，这个太阳伤寒啊，太阳伤寒根本就是体表充实津液了，脉浮紧嘛。也有认为自衄而愈的，古人也说这个衄，鼻出血，是红汗，其实这话似是而非，它是这个血管里头充斥的水分相当地多，所以脉浮紧，它越实啊它越不能出汗，他要有了出血呢，他这个体表，表气松通一下子反倒容易出汗，而能自汗愈的。这个在临床上也遇到过，就是古人呢，说一个人半身不遂啊，摔一个跟头，把脑袋呀磕到石头上了，磕破了，淌不少血，嗯，他半身不遂好了，这事情有的是。我们头前讲这么一节，“服桂枝汤反烦不解者，先刺风池风府，却与桂枝汤则愈”，有这么一节，你们回头看看，那么这个同这一样，他这个太阳中风啊，吃桂枝汤是没错误的，他就由于这个病邪啊，比较深、实，阻碍药力呀反倒达不到出汗，你要刺刺风池、风府呢，也像这个似的，同自衄一样的，使的血液舒通，这个药力反倒发挥了。那么这个呢也有这样的，太阳伤寒是表实证啊，由于鼻衄而好的，这个也有。

那么我们遇到太阳伤寒，发热脉浮紧，这类的病，那么这个人鼻衄而愈了，不要给人吃药了。如果衄而不愈呢，该吃药还得吃药，后头有。这就是根据上边这个，“发烦目瞑，剧者必

衄，衄乃解”这一段，他说不止于多少日子太阳病不好，吃了发汗药，而得瞑眩且衄，病好了，也有这样的。根本就没吃药，他自己鼻子自衄，也好了，不是因为吃药，也有这样的。这是说这个鼻衄啊，与这个病的进退好坏，有的时候有关系的，那么一般说呢，要是表实

证衄血，有好的。总而言之给邪气得找出路啊，邪因衄而解，完了他也出汗，不是不出汗。

李冠杰：前边条文里那个“衄乃愈”，恐怕它的根据就和这条有关，再加上他自己临床的体验，在不该加的地方加上了那么一个说明。

这条在《康平本》里是降一字格排版的条文。按现在所知道的资料，恐怕是张仲景写的，但是我们不能百分之百机械地确定，我们还是从它的学术价值上去看。尽管我们不能单纯地用《康平本》的排版格式去百分之百地界定这三大类条文出自谁之手，但从整体上，把这三类条文分开类来看，确实能发现它们存在明显的差异，它不是出自一个人之手。

我们解读一下：

“太阳病”，在这里侧重于说的是阳性表实证。

“脉浮紧、发热、身无汗”，都是表实证典型的症状。关键是后边论述的重点，“自衄者愈”，这应该是作者临床实践经验的总结。

实际上我们客观地说，在临床中不仅仅是古人有这方面的体验，就是近代的人也有这类经验，近代讲解《伤寒论》的注家们都在说这个事。我都碰到过鼻子破了以后，表实证好了的，比较常见。顶格条文的作者为什么没有去论述？因为病好了，你还治它他干嘛啊！所以，你仔细去看那些顶格条文，可说可不说的话它就不说了。

好多年以前，我有一个朋友，平时也挺欢实的，没看他有什么病。他就有点不舒服，在床铺上坐着好好的，我们在做别的事，他说：“我怎么鼻子破了”？当时都挺害怕啊，拿东西给他擦，过一会看他比破鼻子以前还精神，后来吃了点好饭，后来也没听说他再发生什么病。实际上就是鼻子破了以后好了。

鼻子破了，为什么病会好了？古人基本上是没有解释，我想可以把思路再拓宽一点，中医里有一些放血的办法来治疗疾病，它涉及到经络的循行，从理论上讲它是要放掉里面瘀血，它找到那个地方放出

来的血确实颜色挺深，这个呢恐怕还有待于研究。西方医学在它比较原始阶段的时候，也曾经有过放血治疗疾病的经验，特别是治一些精神方面的疾病，或者说一些反应非常强烈的疾病，它实际上也是对着一些表现为亢奋状态的这类疾病。有记载的某某国家的某某医生，他很擅长于给人放血，西医放血真就是拿着刀子，放完以后看人很平静了，好！抬回去吧。有的人抬不到家因为流血过多就死掉了，也有这种情况。所以这种治疗方法没有传下来。

这启发我们一个问题：为什么鼻子出了血以后，表证反到是好了呢？这有一个事明摆着，人不正常的出现出血，绝对不会因此而提高抵抗力。我们来解释一下看能否说得通：这个鼻衄使人体脱离了体表的过度亢奋状态，那种平衡被打破了，离开了那种状态，这个时候加上精神紧张，可能会出一点汗，体液就有了出路了，反到使体表的功能会比较快的恢复，或者说是它干脆就放弃了抗病的这种能力。因为抗生素治疗感冒就是这种情况，现代医学是严禁用抗生素治感冒的，它的理论里抗生素是不治感冒的，到一些比较正规的大医院里，如果要求用抗生素治疗感冒的话，那些专家、医生都不给你用，都说抗生素不治感冒，你输液干嘛？如果输了抗生素以后，感冒真的能好，怎么好的？纯属用了抗生素的副作用。这个事应该反复地去认识，它不是一个方面的问题，它不仅仅是能够反应现代医学这种对抗治疗方法的不足，同时它也反应了抗生素的一个负面的东西，另外也能反应人体抗病的一个机理。因为西医的理论和制药的人都不承认抗生素能治感冒，但实际上它确实能让症状消失的，就是用了抗生素的副作用。抗生素的副作用这是公认的，没有一点虚假的或者说是强加于人，人家自己都承认。所以说这个问题值得我们深入地去探讨。

这个条文，对《汤液经》的那个条文是一个实实在在的补充，它没有论述到，这儿就把临床当中常见的疾病用明文的方式加到这里边来，应该说是非常好的。《汤液经》相关的条文，我们学的第 46 条，

还有第 55 条它都是论述的衄而不愈的，就是说出了血以后还没有好，还是用麻黄汤来治。那么这儿呢补充了一下，言外之意说不要再治了，因为已经痊愈了，就不用再妄加治疗了。

这条我们做个小结：太阳病，症状表现为脉浮紧、发热身无汗，如果出现鼻衄，并且衄后疾病症状消失的，可视为是一种自愈的现象，不必再给予治疗。

二阳并病、太阳初得病时、发其汗、汗先出不彻、因转属阳明、续自微汗出、不恶寒、（注）太阳病证不罢者·不可下·之为逆·（经）如此可以小发汗、设面色缘缘正赤者、阳气拂郁在表·当解之·熏之·（注）若发汗不彻·不足·阳气拂郁·（经）不得越（注）当汗不汗·其人躁烦·○不知痛处·乍在腹中乍在四肢按之不可得·（经）其人短气、但坐、以汗出不彻故也·更发汗则愈、（注）何以知汗出不彻·以脉涩故知也·（经）若厥文（48）

胡希恕：“二阳并病，太阳初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明，续自微汗出，不恶寒。若太阳病证不罢者，不可下，下之为逆，如此可小发汗”。这是一段，那么这一段主要讲的是二阳并病。那么什么叫做并病呢？仲景这个书讲表里相传，由表传里，或者传半表半里。那么这一段二阳并病呢，就是太阳病传阳明，这是表里相传，由表传里。那么传里，表证还没罢，里证发现了，这就叫做并病。先表后里，表未罢，里证有了，这个就叫做并病。这个并，就是兼并的并，咱们说“秦并六国”，就这个并，吞并的并。那么头一个病，并于后面这个病而发病，所以叫做并病。

那么二阳并病，指的太阳阳明并病，那里头有个解释了，他说“太阳初得病时”，开始得的太阳表证，当然表证要发汗呐，可是发汗，

汗也出了，但是病没好，这个“不彻”就指的病没除，彻当除字讲，就是病没愈，因而转属阳明。那么这个不是说不应该发汗，这个我们以前也讲过，如果这个重的表证啊，你发汗合法，能减其病势而已，病常常的不好的，要是轻病那没问题了。你像我们遇到这个感冒，太阳病轻病，你喝点姜水也好，稍稍出点汗就好。可是真正重病，就是依法来用药，有时都不好的。不好不要紧呐，多是在半表半里，在里这个阶段要好的。这个就是讲了这个情形，他说原来得的是太阳病，太阳病依法当发汗啊，发了汗了，但是病并没有好，因为这个样子呢，这个病由表进里而转属阳明。

这个阳明病啊，他搁个“续自微汗出”，这是阳明病的一个外证的反映，我们后头讲到阳明篇就有了。“阳明病，法多汗”，阳明病是胃肠里边有热，热结于里嘛。热结于里，蒸发于外，所以老出汗。

“续自微汗出”，老要微微地绵绵不断地出汗，这就是转属阳明病了。那么既然并病，太阳病还存在啊，所以我们不要冒冒失失就要吃泻药，如果我们看太阳病还存在，主要的身疼痛、恶寒还有啊，这个就是不可下，下之为逆。你这阵儿别光看阳明病了，应该下，可是表证在，不能下，这是定法。那么必须先解表。下之呢？下之就是为逆，逆就是逆治，就是治错了。那么这个应该用什么药发汗呢？当然用桂枝汤，它可小发汗，他“续自微汗出”嘛，咱们讲桂枝汤讲的多了。凡是津液有所损伤之后的这种表证，全要用桂枝汤。他这个书上没说，但是言外之意告诉你用桂枝汤。这是第一段。

设面色缘缘正赤者，阳气怫郁在表，当解之熏之。这又一段。他说在太阳病期间，发汗之后，有的转属阳明而为二阳并病。这也不一定都二阳并病，他底下有这么一段，这以前都学过的。他说假如这个人“面色缘缘正赤”，就是整个的面色都红，这还是表不解的现象啊，这是阳气怫郁在表，还是不得汗出的一种问题，这与二阳并病没关系。

“当解之熏之”，解之就是以小发汗法来解之，我们头前讲那个桂枝

麻黄各半汤，桂枝二麻黄一汤，都是这种情况。也可以熏之，古人啊为达到那个小发汗的方法，也有拿荆芥、艾蒿这一类的（药）熏，用个盆子把它们煮成汤，趁热的时候，身上覆盖了，熏，也可以出点小汗。“解之熏之”，解之就是小剂的（发汗药）发汗的方法，来解其怫郁在表的外邪，这不关乎里边的事。或者是熏之，稍稍出点汗就好，这个病不要紧的。这又一段。

“若发汗不彻，不足言阳气怫郁不得越，当汗不汗，其人躁烦，不知痛处，乍在腹中，乍在四肢，按之不可得，其人短气但坐，以汗出不彻故也，更发汗则愈。何以知汗出不彻？以脉涩故知也。”那么这一段呐，根本就是发汗不到家，所以病不好。这个“不足言，阳气怫郁不得越”，那（面色缘缘正赤者，阳气怫郁在表）是个微末的表证不了了的小病了，这个病不是的，你不足以说这是阳气怫郁不得越，这个要重得多了。这是当汗不汗，还应该发汗。你看这个人他也是躁烦。躁烦，以躁为主了。这个说明表不解而发烦躁得厉害，就是当汗出不得汗出的意思。他是身上哪都疼，没有定处，这是表证，大概哪儿都酸疼，自己呢也不知道在哪，有时候在四肢，有时候在腹中，但是你摸那，哪也不是，按之不可得。那么由于表不解，不得汗，这个气往上涌，所以“短气但坐者”就是不汗出而喘，他躺着气上不来，这个热往上涌的厉害，所以这种情形呀就得再发汗，“不解之熏之小发汗”都不行。这个情形咱们看出来是大青龙汤证，肯定要用大青龙，不汗出而烦躁嘛，这就是咱们头前讲的那个青龙汤就是。那么怎么知道这是汗出不彻呢？由于他这个“脉涩故知也”。这个脉涩呀大家都是根据这个经文呀，这个脉的不及，有的因为这个邪盛阻碍这个血行，而不流利，而发生涩，这是大家一般的解释，可是叫我看这个脉涩呀，总是有些问题。他这个脉涩不可发汗，你还怎么发汗，而且这个涩脉是一个关于血液在内的流行的一种反应，凡是涩脉都是虚。真正实而见脉涩的还真少，是不是这个脉涩呀应该是脉紧呀或是脉浮，

我看是较对的，也许是错字，但是现在大家都是根据这个条文的解释，说是实的太厉害，当汗出不汗出阻碍了血行流畅，这也有涩的现象，但这种涩它绝对是有力的。这是各家都这么解释，这么解释也能解释的通，但是事实上我没遭遇到这种情况。拿我个人的经验，真正的这种表实证而脉现涩的，在理论上讲，讲不通，恐怕这个应该是脉浮，因为他这个脉浮还在表嘛，再不就是脉浮紧，这个是比较对的。这个脉涩，这个书里的错字很多，这个暂时先搁在这个地方，你们看各家的注呀，全是我头前说的那个，就由于表实的厉害，不得汗出，这个血在这个脉里头反到受了阻碍了，这么一种涩，他把这个涩呀，不按着一般涩者为血虚，津液少，不是那个解释法，我认为这是敷衍古人的论说了，这个不一定是对的，但这个不关乎重要。这个头前这种情况，不汗出而烦躁，一点汗也没有，那么这类的情形再发汗就好了，也不关系二阳并病，他这二阳并病呀就是指头一节。那么开始太阳病，后来也依法治疗，发过汗，虽然汗先出，但是病不去，那么这样子呢，因而转属阳明。表证没去，阳明病就有了，所以续之为汗出，就是一个阳明病的外证了。那么这个时候怎么治这个并病呢？并病当然是表证没好先解表。就看这个并病里证如何。他这个二阳并病，它是太阳病与阳明病的并病，如果他外边有表证，里头他是一种虚寒的这类的，你看少阴病与太阴病的并病你就不能先解表了。

那么也有太阳病传到太阴的，也有的。那么里虚寒，你就不能先解表，当先救里，头前有过。那么下利清谷，可是身体疼痛，那你得先救里，而后治疗身疼痛。身疼痛是表证的，也表没罢。这在他这个书里头呀，在临床上都挺重要的，这也是一种定法，咱们在临床上也是，这个人多少日不大便，他这个里实呀很清楚，很明显，但是他还发烧怕冷，这表证没罢，你不要先给他吃泻药，还要先给他解表。解完表了，你再给他下里，所以古人有一句话呀，说是“下不厌迟”，说是该下的病，缓了没什么大害处。如果里边要是个虚寒的病，就是

有表证，也要舍表救里，这在临床上都是定法。你要是不守这个办法呢，那就是为逆，那就不会好病的，这个咱们要知道。至于这块这个脉涩呀，要我看应该是个错字，可是各家都不说他错，就那么个解释法。说是太实了，血液受阻，所以脉也涩，这么个看法。

李冠杰：这是《康平本》原来的面目。

这一段文字因为嵌注、旁注非常多，而且正文又比较零乱，跟《宋本》这一条原文的差别稍微大一些，除了有几个字以外，还有一些地方给省略掉了，大家可以去对照一下就会有这种感觉，《宋本》绝对是在《康平本》的基础上经过润色以后写出来的。我们看《宋本》如果仅看字面你没有什么感觉，你只知道这是一个，长了一些，可能句子之间稍微仔细品一品，有点不太通顺；但是我们一看《康平本》这问题一下就发生了很大的变化，敢情原来是这个样子的。

要想学好这个条文，我们必须借助于《康平本》这种排版格式，先从文字排版上重新的给予审视。一直以来，大家都是按照《宋本》的那种格式在研究、在学习，谁都没想到这个条文敢情原来是这个样子的，甚至这个条文最后还有不完整的内容，掉了一大块儿的内容，都不知道是什么？这根本是以前的人想都想不到的。

首先从《康平本》上，我们可以明显地看出这是个残缺不全的条文，不仅仅是后边有一个“若厥文”，“若”就是说还有另外的情况，“厥文”就是文字丢失了，缺字的意思，后边内容缺了，所以说这本身就是残缺不全的。

再看后人又加了这么多嵌注、旁注，我们可以想象，写在竹简上的这个地方已经破了或者让虫子给蛀了，或者其他什么的，已经很难看清到原来的面貌了，那就给加一点注解吧！就是这么来的。咱们看正文的文字是相当不连贯的，里边穿插着一段一段注解文字，这种不连贯我们就不排除它有内容残缺的这种可能性，但是现在已经没有可靠的史料可查了。

对于这个条文里边的嵌注和旁注的内容，咱们本着能够最大限度的继承有用的东西，去其糟粕，咱们一点一点的分析，好的就把它保留下来，不好的就把他摒弃掉，原则应该是这样。这些注解，包括以后的注解文字，凡是对症状的论述都应该引起我们的重视，因为症状很少有人去凭空捏造，大都是这个作者有类似的临床经验总结而来的，这是一个原则。

另外一个原则，就是凡是注解的解释道理的，我们要严加分析，合乎经方理论的咱们就继承，不合乎的，相悖的或者是错误的，咱们就该应该把它剔出来。

从这个条文里边，仅从反面的角度上，就能很有力的证明《康平本》的真实性。大家再看看，比如最后的“若厥文”三个字，这不可能有人去造这样的东西，一定是有这个问题存在，只是后来的版本就把它给删掉了，因为它没有实际意义，但是我们今天看到以后，却从无意当中，从一个侧面证明了《康平本》是一个真实的，绝不是伪造的。我们学到这儿才学了将近 50 条的样子，大家是不是有这种感觉，我们借助于《康平本》澄清了历代都模棱两可、争议不休的若干问题。

下边解读一下这个条文：

“二阳并病”，这儿它指的是太阳病没有解又出现了阳明病，它也可以是太阳病和少阳病并病，也叫二阳并病，这个条文里边指的是太阳病和阳明病并病。并病就是前边的病还没好，后边又发生了新的疾病，两个疾病合并在一块儿就为并病。

“太阳初得病时先发汗，发其汗，汗先出不彻因转属阳明”。这儿有两层意思，一个是它论述太阳病，它想跟你说明，这是一种比较特殊的情况：本来太阳病发汗就应该好的，但是有发汗以后，不但太阳病没有好，反倒是生了里热出现了阳明病。第二层意思，是以具体的发病过程为例，解释并病的概念。并病是什么？实际上这里面有了并病的概念了嘛，太阳病初得的时候，发汗没好，又出现了阳明病。

怎么知道它出现阳明病？“续自汗出”和“不恶寒”，就是阳明病的典型症状。但是我们想问题应该周到一些，“续自汗出”就是他发汗以前是实证，但是吃了发汗药以后，汗毛孔打开汗出，但是这个时候产生了里热了，里热迫使体液再进一步地往外出，这个时候表已经因发汗药的这个力量，它就处在一种表虚的状态，所以它来一个“续自汗出”，既有表虚的因素，又有里热的因素。

关键是下边有一个“不恶寒”，太阳病明显是恶寒的，这儿有“不恶寒”这个特殊的症状，这就不是太阳，超出了太阳病的范畴了。

“如此可以小发汗”，像这样的情况可以用小发汗的办法，这是指治疗方法。这一条重点不是讲治疗，只是给你一个方法，具体的方剂你可以自己去推敲了。比如桂枝二越婢一汤，甚至桂枝越婢各半汤，也未必不行，要看当时对他的症状的判断，包括桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤都属于小发汗。这个已经有了阳明里热，我想恐怕是越婢汤可能会更好一些。实际上这地方重点讨论的不是这个，它重点讨论的是出现了这种情况，你的治疗方法就得跟着变。

我们在考虑另外一个因素，这个“不恶寒”和“如此可以小发汗”之间，是不是还有缺失的内容啊？我们并不排除这种可能性，但是已经无从考察了。这里只是说学习这类条文，你不要把它看得很绝对了，就像我们以前按照《宋本》都解释的头头是道，结果拿出《康平本》一看，傻眼了，不是那个样子。

“设面色缘缘正赤者，阳气怫郁不得越，其人短气，但坐”，我看这个地方啊，是把顶格排版的这些条文，也就是说《汤液经》的条文全都连到一块。连到一块以后，我们感觉它大概还能说清楚一些大概的轮廓。

最终也是“更发汗则愈”，像这一类的情况，脸色老是发红，人也短气，但坐，这是属于“阳气怫郁不得越”，是这么来的，还得用发汗的方法治疗。言外之意，是不是不要把它当作阳明病去治？但是

在这个地方我们不要去推敲得太细了，因为你推敲得越细，其实你越没有底。因为这个条文是不是一个原样？原样是什么样子？我们已经不得而知了。这肯定是个残简，有残缺的一个条文。

“若厥文”刚刚已经说了

下边我们再来看看，这个条文里边的的嵌注和旁注的内容。我们继承的古人的东西，《伤寒论》就这么薄薄的一本书，里边只要有的东西，不管它对和错，我们都应该认真地去对待它，我们对这些注解文字也简单地看一看。

先说嵌注：“太阳病证不罢者，不可下，之为逆”，《宋本》加上了一个“下”字，“下之为逆”，这是对的啊。这个地方重复了太阳病的一个治疗原则，太阳病不可下，太阳病还不好的时候，不能用下的办法。

嵌注“若发汗不彻，不足”，“不足”这两个字已经把意思表达清楚了，在《宋本》里边还有一个“言”字，不足言，就是说不够吧。

“阳气怫郁”这些文字是在解释阳气怫郁的机理，跟上一条在病理上有些相似，因为发汗不够，体液还有一部分该出的出不去。但是这儿跟后边的治疗方法是可以统一起来的，因为发汗不够，还要发汗嘛。

下边“当汗不汗，其人烦躁，不知痛处”。“不知痛处”前边还缺一个字，是什么恐怕也不知道了。“乍在腹中乍（这个地方没有‘在’，这个‘在’是个缺字，应该是一个‘在’）在四肢，按之不可得”。像这些症状没有什么很难理解的，在字面上一看都能知道，就跟现在我们的的大白话有点差不多，一看就能明白。但是这个都是说的症状，恐怕是作者在临床当中碰到过这样的病人，而且他这种描述也是比较贴合现在的，也就是说表实证比较严重，发一点点汗，没有彻底好，其实人体还是表现一种亢奋状态，可能会出现这么一种症状。

后边“何以知汗出不彻，以脉涩故也”。像这种文字就不是很好，可能是在临床当中，他碰到的一个和几个病人，表现脉涩的多，也不

排除这样的病人容易出现脉涩。但是把这个绝对化不好啊，说这种情况的人都会出现脉涩吗？恐怕不一定。

下边看旁注内容，“在表”是接着“阳气怫郁”啊，“阳气怫郁”在哪？他的意思就是说在表。在表就应该解之熏之，他错就错在这个“熏之”上。在表当解之没有问题，无非是可有可无，你不做解释别人应该也能看出来，最起码从理论上不相悖。但是这个“熏之”是一个绝对性的错误，在经方理论里边，没有那一个病是用熏的办法来治疗的，而且不仅仅这样，经方从不示人用火攻的办法，相反，经方书里边有多处论述这个火攻的危害，对这个火攻实际上是不赞成。

这个条文里边等于是有三个作者，一个是顶格原文的作者，一个是嵌注的作者，一个是旁注的作者。当然这里嵌注和旁注能不能截然分开？它不是出自一人之手？这事我们也很难去分开，但是从刚才的分析，明显能看出来，确实作者之间水平差别还是比较明显的。

下边做一个小结：太阳与阳明并病，太阳病初得的时候，便以发汗的办法治疗，但是，虽已有汗出，病却没有痊愈，反而出现了阳明的证候，其症状表现为，续自汗出，不恶寒，像类似情况，可以用小发汗的方法治疗。假设患者面色缘缘正赤，并表现为短气但坐的，则是由于阳气怫郁而不得越，还需要以发汗的方法治疗。这样咱们小结里边就把那个注解文字啊，就没有把它纳到里边来，意思有了。

脉浮数者、法当汗出而解、若下之、身重心悸者、不可发汗、当自汗出乃解、所以然者、尺中脉微、此里虚、须表里实、津液自和、便自汗出愈、（49）

胡希恕：浮数的脉，这应该是表证呀。依法当汗出而愈，根据我们治疗的这个方法呀，应该发汗，汗一出就好，这是一般的表证呀。脉浮数，浮为在表，数为有热，这个表有热的病呀就是太阳病。那么

大夫不给吃发汗药，而吃泻药，若下之，这是逆治了。那么这个下之则病变多端，这是取其一例。

如果误下之后，“身重心悸者”，不可再发汗了。那么这个头前我们讲很多了，下之后，其气上冲呢，那表证还存在，还是要解表，还要用桂枝汤了。他这都是反复地说，你不要守定一个，拿着个别情况当全体就是不对的。也有这样的，下之后，伤了里了，虚其里了，所以外边这个气郁而为湿，身重，就是里头有些湿，水分，停水了。咱们人身上这个营卫在体表老流行，那么停水就变成湿，身上有湿就沉。那么里虚血液就不足，血不足以养心就悸就跳。

这个心悸与心下悸不一样的，这个书里心下悸都指着胃那个跳，胃跳都是胃有水。咱们头前也讲了，心下有水气，就是有停饮了，这是在《金匱要略》上的，所以这个胃中有留饮，微者短气，这个留饮少气短，他这个压迫这个，往上压，横隔膜受阻碍，人就短气。这个停水多呢，甚者悸，心下悸。这个他说的不是心下悸，说的是心悸，就是心脏跳。这个血通于心呀，由于虚其里，这个胃气虚呀，这个津液血液都要虚的，因为胃为水谷之海，营卫之源嘛。他要是一坏就不行了，这个是给他吃泻药，里头没病给他吃泻药，虚其里，不但外边湿郁于表而体重，而且血虚于内而心悸。这样子不要吃发汗药了，不可发汗。

“当自汗出乃解”，这个他要津液逐渐回复，他自然就出汗，这个病就要好的。为什么要这样呢？他这个下之后了，“尺中脉微”，这个微是气血不足，俱不足，这个脉微。“此里虚”，他是里虚造成的。“须表里实，津液自和，便自汗出”，须，当自汗出，他又一个须，当、须这都是含蓄的语意。是不是当大夫的就等着他自己恢复呀？也不是的。他里头告诉你不要再解表了，不要再发汗了，你要在这些方面注意的。他是里虚了，主要的他里不虚了，他就表里自和。所以他搁个当自汗出，须表里实，这个里头呀都有一个让你斟酌治疗，可

是这个证候呢他只是指一个身重心悸，这么一种证候，当然他没举全了，这两个说明由于里虚造成外有湿郁，内有心悸，血不足。那么这个治疗后头有的，你像这个时候应该用这个，大概小建中汤比较好，小建中汤治心悸烦啊，也有桂枝加芍药生姜人参新加汤，后头也有。总而言之得想办法实里，里虚。补虚扶正的话，他这个血液津液自然就恢复的，那后头有，所以在这儿只是告诉你不要再发汗了，应当使他津液复，须表里实，他就好了。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边是降一字格排版的条文。

这个条文跟《宋本》相比较的话，只有一字之差，就是“法当汗出而解”，《宋本》是“法当汗出而愈”，这个没有质的区别。

下边我们解读一下：

“脉浮而数”，实际上这个地方啊，就是指的太阳病而言。如果把这个地方放上“太阳病”三个字比这个“脉浮而数”还要确切。他之所以用了一个浮而数，太阳病常常伴有发热，发热的时候，人的脉一般都是数象的，心脏都会跳得快。

“法当汗出而解”，有时候阳明病也会出现浮而数的脉。所以我们不要认为脉浮而数的，一定是个表证，一定会汗出而解，不一定。那么这个地方我们应该怎么理解呢？应该理解为表证。前边他就是想说太阳病嘛，太阳病就应该用发汗的方法来治疗。但是不排除这里边包含自汗出，也可以痊愈的这种情况。

“若下之”，表证用泻下的方法那肯定就是误治了。误治以后，会出现些变证。

在这个地方举了一个例子，“身重心悸”这一类的情况。就是因为误下以后，造成里虚而且有停饮的这么一种情况。这个“身重”，就是说因为有停饮，所以感觉到有身重，不仅仅是停饮这一个因素，还有一个因素就是里虚。里虚了以后啊，人体处于一种虚弱的状态。我们这个地方，老百姓有一句土话叫“好汉经不住三泡稀”。就是说

泻上三次，挺壮的一个汉子也会浑身无力，也有这方面的因素。“心悸”，有很多方面的因素可以造成心悸。心悸出现在这个条文里头有前提条件的，“若下之”，下了以后，短时间内人泻下的太重了，造成里虚。里虚了以后，胃肠功能急速地下降，人体体能就会不足。这个时候就必须由循环系统加快循环来代偿。我们说句土话啊，就是拉肚子拉的心慌，就是这么一种情况。

像这种情况就“不可再发汗”，就是有表证也不能再发汗了。这儿呢，“不可发汗”，又强调了经方的一个重要的治疗原则。其实这个地方呢，面还要宽一些，不管有里虚也好，还是里有停饮也好，都不可单独的发汗。这里边应该包含着这样的意思，我们理解最起码应该理解到这个层面上。

“当自汗出乃解”，如果从字面上看，那就是等着他去出汗吧。你不要管他，等着让他自己出汗，出汗以后他的病就好了。

为什么？“尺中脉微”。在经方里边，尺脉候里，寸脉候表。“尺中脉微”就是里虚了，“此里虚”。这个地方提出来一个里虚的概念，这很重要。那么里虚，有没有表虚啊？也有表虚。

这就有一个里和虚，这是两个问题了。这个里，是一种疾病类型，是发生在消化道里边的症状反应。虚，是一种疾病性质，津液虚了。腹泻造成脱水，胃肠功能不好又导致水分吸收差。整个循环系统血容量减少，表现为脉虚。此时津液虚，血容量不足，故不可发汗。

这里就涉及到了两个要素：一个是里证，一个是虚证；一个是疾病的类型，一个是疾病的性质。

那么下边，“须表里实，津液自和”，是治疗的原则。应该先去治里，把里虚证给他治好了，津液自和。津液问题解决了以后，“便自汗出而愈”嘛。这个时候，才有可能或自愈，或再用解表的方法把他治好。

他写这个条文，他见过在临床当中有这样治了以后，不用去发汗，

等待病人消化道功能正常，津液恢复后，自会汗出表解。这个从理论上也能讲得通。人在里虚到这种程度的情况下，他还表现为表证，也就是说他还有能力在表这一层跟疾病做斗争。如果把里恢复了以后，里边状态改善了，产生的能量也多，就可以增强在表这一层的恢复能力，这个病有可能自愈，也是可能的。如果自愈不了，其实去治，也没有什么不好的。小建中汤就是这一类的，对的就是这一类的疾病。不一定非得用小建中汤，具体情况具体看啊。

咱们通过学习这个条文，大家是不是品出一个问题，这个降一字格条文，明显得比顶格条文论理的成分多。在病理方面、辨证方面，他有一些自己的理解，写在这儿，对理解经方理论，起到一个说明的作用。他本身就是一个经方理论的归纳。

做一个小结：

太阳病，本应得汗出后而解除，如果误下，患者出现身重心悸的，就不能再以发汗的方法治疗了，此时的患者表现为尺中微的脉象，说明人体已经因误下，而发生了里虚停饮的病理状态，所以不能再发汗，应该酌情以适当的方法治疗里虚停饮证，当人体里证治愈后，方有可能达到汗出表解的目的。

脉浮紧者、法当身疼痛、宜以汗解之、假令尺中迟者、不可发汗、何以知然、以荣气不足、血少故也、（50）

胡希恕：这个浮紧脉就是太阳伤寒脉，表实嘛。那么这个它表实，身上一定疼痛的，它受到毒素的刺激加上这个体液的压迫，所以它疼的厉害。那么这个呢应该发汗，“宜以汗解之”。所以这个临床啊，我们不能片面的看问题，看他脉浮紧身疼痛就吃发汗药嘛？你还要看看脉。除了这个浮紧，你再看看还有旁的脉没有，如果同时有迟，尺中迟这个脉都迟啊，就是浮紧而迟的脉呀，尺不是说尺中的脉迟而寸

脉数，哪有那事啊，这血管就是一条，心一动脉一跳，脉一跳三部脉它全跳啊，这个脉跳那个脉不跳，没那个事。他搁个“尺中迟”干什么呢？仲景的脉法呀，他是浮沉以候表里了，关的前后也候表里，这都是《金匱要略》里的：脉浮者在前，其病在表。关以上浮那准是表证，关以下浮上面不浮那就不是表证了。这个脉呀没有至数上的不同，可有形状的不同，这是肯定的。我们说的那个促脉，就是寸上浮所以他表不解嘛，那是表证。那这个呢，他特意搁个尺，仲景这个脉法呀，关以上候表，关以下候里，他特别提出来尺中脉迟，就是三部脉全迟，他提个尺干什么呢？告诉你这是里，此里虚，以营气不足，血少故也。说是脉内的营气不足，血少的缘故。凡是津液虚血少的都不能发汗，这个发汗啊，亡失人体的体液是最厉害的，所以你亡汗也亡血，这后头都要有的，我们慢慢的讲。所以这个不能发汗，怎么办呢？用上边的那一条诠释。虽然我们在临床上遇到这个表证，看看都象发汗，你看看有不可发汗的情况没有，如果有，这个汗不能够随便发。这两条诠释的是这个，应该怎么救治，后头有的。这个脉迟正说明里虚，就是前面我说的新加汤啊，就治这个。后头有的，现在先不管。

李冠杰：这个条文也是降一字格排版的条文。

“脉浮紧者”，这是典型的太阳伤寒的脉象。

“法当身疼痛”，跟前一条是一样的，在这个地方，他这儿就说的表实证的典型症状。“脉浮紧，法当身疼痛”，实际上就是在说太阳伤寒麻黄汤证，就这么一个意思。

“宜以汗解之”。太阳表实证，经方里边说发汗一般都指麻黄汤，这也说是正治。

“假令尺中迟，不可发汗”，这个地方是举的一个例子。如果出现脉象“尺中迟”的这种情况，你就不能发汗了。这儿，整体读的话，就是要讨论表实证，但是不可发汗的一个例子。可是，“尺中迟”，恐怕这地方有错误。我们现在看到的就这几个字，我们只能说他不足

为训。人体的这个脉啊，在搏动次数上全身所有的地方都是一致的，不可能出现寸关尺有的地方快有的地方慢，寸脉急促，表现数脉，尺脉反而表现一个迟脉，那可能吗？不可能的事。我们今天看到的这个条文就是这个样子，那么怎么办呢？我们绕过脉象，就我们只当没有。

下边是什么？“以荣气不足，血少故也”。这是这个条文的关键所在。荣气是什么？跟营气是一回事，指的是人体运行于血管内的水谷精微。这是古人的解释，按我们今天的说法呢，就是血液与血液所输送的人体通过胃肠吸收的各种营养成分。血少在这儿，还是对荣气不足的一个具体解释。说荣气不足，怎么不足了？血少了。这是他的一个具体解释。

我们把这个条文换一种方便理解的讨论方式，再审视一下，可能对这个条文的理解更有帮助。当人体表现为表实证，如果同时还存在着里虚血少这种情况，就不可以发汗了。应当首先治疗里虚证，应该是这么一个意思。

这一条跟第 49 条讨论的是一个性质的问题，但是具体情况不一样，那个有停饮的问题，这个没提到停饮，这个是以里虚为主的。

这一类的情况，像新加汤，或者桂枝人参汤之类的，都能解决这一类的问题，但是他得有具体的证。

下边做个小结：太阳表实证，多有身疼痛的症状，应该以发汗的方法治疗，但是如果同时存在里虚血少的证候时，不可发汗。

脉浮者、病在表、可发汗、宜麻黄汤、（51）脉浮而数、可发汗、宜麻黄汤、（52）

胡希恕：这它是简文啊，那桂枝汤它脉浮不，也脉浮。脉浮病在

表这是肯定的，那就得用麻黄汤发汗吗？这不一定的，这是个简文，因为桂枝汤麻黄汤已经反复的说了，头前都有了。那么就是脉浮无汗者，它起码有个无汗，那么这类的表证必须用麻黄汤发汗，这是简文，这书里面很多。52条跟51条一样，只是脉浮而数，桂枝汤也脉浮而数啊，那么如果自汗的话，要用桂枝汤，无汗的要用麻黄汤，这和上面是一样的。而且表实证不光是无汗，头疼啊，腰疼啊，骨节疼啊，这都是麻黄汤证，这是必有的，同时这个人恶寒。那么这两条呢，它是同桂枝汤的一个划分，那么就是以有汗无汗来说，但它这个含在里面没有明说，他这个书全是这样的，头前讲过了，在这里就简略了，但是读书的人呢，到这个地方就不能死于句下，脉浮的就用麻黄汤，浮数的也用麻黄汤，就都错了，不是这个事啊，因为他前头说了，所以在这里简约言之。

李冠杰：这两条在《康平本》里是同一段内容，在《宋本》里把它拆成了两条。我们把它当成一条来学就行了，内容把它分开，放到一块儿来学习。

“脉浮者，病在表，可发汗，宜麻黄汤。脉浮而数，可发汗，宜麻黄汤”。这条是降两字格的，一般认为这是王叔和写的。

为了客观地对待条文，不能见了王叔和的条文就一棍子打死，我们先把这条做一个小结，就跟直译差不多：脉浮者，而且又处在表证的病理阶段，可用发汗的治疗方法，适宜麻黄汤。

我们现在理解这个条文，必须这么理解，不管作者的原意是什么。如果还有另一种理解：如果这个人脉浮的话，就应该是表证，就可以发汗，就应该用麻黄汤。这种理解不好，只能会让你越学越僵化。碰到脉浮就说是表证，那要是里热呢？那要是白虎汤证呢？如果把脉浮者理解成病在表，它表现为脉浮，其他的疾病反应都在表证的范畴之内。病还是个表证，就可以用麻黄汤。这样理解条文就显得价值比较高了，我们学到的东西也比较多。古人的好多东西，我们必须得这么

去理解，如果真要那么理解的话，就呆板了，从中获益就非常少。

第 52 条，脉浮而数可以用发汗的方法来治疗，适宜用麻黄汤。

这两条条文非常得简。它有言外之意，就是说麻黄汤证不一定表现为脉浮紧，这两条一个是脉浮，一个是脉浮而数，都没有提到脉浮紧。它这儿说了另外的一个情况，就是说麻黄汤证并不一定准是个脉浮紧，它或是浮数，或是得有别的症状。所以，如果我们前边这么理解病在表，说它不单单是脉浮，而且还表现为表证的疾病反应，也就是说它还处在表证的病理阶段，就用麻黄汤。当然，咱们理解别的条文也得这么理解，得一视同仁呢！

后边给了方剂，就是麻黄汤。麻黄汤肯定得是表实证，如果表虚证有汗出，你还能用麻黄汤吗？这个条文如果这样理解，还应该有一点可取之处的。但是深入的剖析，整体在参照其他条文就会发现，尽管我们用了打圆场的迂回方式来理解，能把它说得比较有道理，但是这两条还是纯属多余，完全没有必要。

为什么这么说？首先，这两条所论述的这个主要内容就是麻黄汤证现浮脉，而且也不一定是浮紧的脉，就这么个意思。有时候是浮脉，有时候是浮数的脉。为什么说它多余呢？第 232 条是这么写的：“脉但浮，无余证者，与麻黄汤”，比这个条文更科学，“脉但浮”就是说脉仅仅是浮脉，也没有浮紧的脉；“无余证者”，什么叫余证啊？后边有方剂啊，麻黄汤。这个条文就是说，如果患者不是浮紧的脉，仅仅现是浮脉，但是它麻黄汤没问题，是不是？所以说这个问题在别的条文已经有了，要一比较的话，这条就是纯属多余，多此一举，而且显得水平那么低。顶格的条文文字用得少，说得还清楚。第二个方面，就是麻黄汤证也可以现浮数脉。太阳病有一个典型的特点就是发热，发热的脉有不数的吗？脉浮数是麻黄汤证，很多条文都能看出来，这个地方再写，没有意义。另外一个，麻黄汤的其他论述，比如第 232 条，它就有一个新意，刚才我们解释了。其他的也都有新证，比

如说以前是个麻黄汤证，鼻衄（鼻子破了）以后表证还不解，麻黄汤证还在，还得用麻黄汤。它出了新的症状了，教你怎么去辨证。像现在学的这两条它有用吗？

我们通过学习这几条，给大家延伸出一个问题来，就是说在经方理论中没有以脉定证，或者以脉定方的这种规律存在。凡是涉及到这类条文，都要去反复地审视。

前两周有这么一个病人。现在临床当中有一类这样的病人，特别是经过长时间的了解现代医学知识以后，或者在医院里看病次数多了，他们逐渐养成一个习惯，他只是想让医生给看病，但是不觉得这个病跟他自己有什么关系，他觉得我就是给你把病说清楚了就行。这个病人还是一个单位上的领导，他就跟我说：我心脏不太好，尿糖比较高，有糖尿病，血压有点高，其他就是口干、老想喝水。这个口干、老想喝水对我们来说是“口干欲饮”，这是明显的症状。再问他别的，他说：我其他的没有什么明显的不舒服的感觉。就好像是他把病说给你，你就应该能给我治，就是这么一种理念，所以说平时他也不是特别在意。后来我细问了一下，又通过把脉、看舌，最后给他的是白虎加人参汤。他吃了两天以后反馈信息说：我吃了以后感觉还可以，就是胃里边觉得有点不好受。我又想了想，当时在诊断的时候，他说以前体质不是特别的好，我想他可能胃比较弱一些，又给了他一点吴茱萸汤。吴茱萸汤跟白虎加人参汤正好是反着的，让他跟白虎加人参汤混着喝，但是吴茱萸汤的量大概三分之一的样子。他喝了大概七八天以后说：我感觉很好！原来他的脉是洪大的，脉搏跳动 110 多次，但是不感觉有明显得心悸、心慌，第二次再来看的时候心跳就明显降低了，降到 90 多次，“口干欲饮”也减轻了。后来我又给他弄药，我方剂都已经确定好了，准备做药的时候，他自己无意中说这段时间小便特别的味儿。我马上就问他：你有时候比如刷牙或者什么的，会不会有想干呕、想吐的感觉？他说：这毛病老时间长了，都好多年了。

这是一个明显的症状。另外一个我问：你是不是有时候感觉一阵发冷，又过一会儿又过去了（那段时间，因为他脉里边带着有明显的柴胡证）？他说：我房间里的空调挺凉，但是有这种感觉，是不是跟空调有关系啊？我说：如果跟空调有关系，你会老觉得冷，它不会一阵一阵的。这样，方剂中就给他加上了小柴胡汤，他喝了以后效果还是挺好。

这个地方有一个什么体会呢？就是说经方的精髓就是方证相应。我们辨证也是重点关注症状反应，根据症状反应，辨证的过程当中确定它的症结，是有里热了，还是有里寒了，或者说有水证了，最终再确定一个合适的方剂。

我们现在就根据胡老奠定的基础，脏腑辨证不是一个重点，但是在辨证的过程当中会用到脏腑辨证吗？也会用到，包括西医的一些诊断结果都能作参考，但仅仅是个参考。像这个病例就是一个明显的例子，他说小便特别得味儿，那么要按脏腑辨证，他应该是肝脏或者说肝胆最起码状态不好，有可能断为肝火旺。根据他小便味道特别得重，我就会参照脏腑辨证想到了肝胆不好，肝胆不好首先就会想到柴胡剂，虽然说柴胡剂不是专门用来治肝胆病的，但是它在肝胆病上应用的几率是比较高的。那么根据这个思路，再去问有没有柴胡剂的症状，这才是最主要的，脏腑辨证在这儿就起到了辅助作用。其实这些东西好多也都是来自临床的，如果按照脏腑辨证一路想下去，再去按脏腑辨证确定方剂的话，那就成问题了，这个咱们讨论不是一次了啊。在辨证上来说，经方辨证是最高的一個层面，其它的辨证拿过来就用，凡是跟临床能接轨的，我们放到经方里边都没有什么水火不容的，都不是那个样子。

病常自汗出者、此为荣气和、荣气和者、外不谐，以卫气不共荣气谐和故尔、以荣行脉中、卫行脉外、复发其汗、荣卫和则愈、宜桂枝汤、（53）

胡希恕：“病常自汗出者”，那这就是单独一个证了，就是经常出汗的病人呐。“病常自汗出者”，就是常自汗出的病。这个汗出啊，就是咱们头前开始讲的中风证，阳浮而阴弱呀，按到脉里面才弱。那么这个汗出，这是由血管里头伤于营啊，他说此为荣气和，虽然关系到脉内之营，但是这个毛病啊，在营没有什么责任，责任应该在脉外之卫，由于这个卫气不共荣气和谐故尔，这是什么意思，在这儿我把这个气、血、营、卫跟大家说一说。

古人是这么来看人身的体液的，这个体液古人只能看到这么一点，古人不知道造血器官啊，他就知道饮食入胃，那现在的话来说，就是经过胃消化之后，它要进血管，古人这个他知道。那么化而为赤呢，古人叫做血。一进血管就是红的，古人叫做血，出了血管古人叫做气，这个血与气呀都来源于饮食，这是古人的看法。那拿现在的意思呢，就是我们饮食入胃了，营养成分那，血管给它吸收出来了，然后输送到人的周身，这个就是拿现在话说就是营养成分。那么古人给这个东西叫什么呢？叫精气，这个精气呀就是养人的精真之气，人非它不能养，这古人也说的挺好，这个东西呀不到哪哪不行，但是他说的有点问题的，他说脾为胃行津液，输送到四肢百骸，不到足足就不能行，不到手手就不能握，古人看的東西就是疏，不密，他就是概要的说，饮食入胃，在血管里头色赤为血，就是其精者嘛。其悍者，不在血管里头在血管外头，那叫气，古人这么看。

那么气是什么样呢？我说的这些都是《内经》上的你们看一看就知道了，看看《灵枢营卫篇》上就有。这个气如雾露之盖，就像下雾下露水似的，遍布人的周身，哪都是，甚至于润泽皮毛，也都是气的作用。如雾露之盖，那就是指的津液。不过它不在血管之内，在血管

外头。古人也知道这两个东西它互相起作用，这《内经》上也有啊，说：夺汗者亡血，夺血者亡汗。他也知道血管内外通透，这个他知道的很，你看你发汗大了血也没有了，失血的人也没有汗，再不能发汗。那么他说的营卫是什么呢？他说在血管里的作用，就是血的作用叫做营，营以周身嘛，也叫做荣，咱们这个书上是荣。那么血管外气的作用呢，他叫做卫。所以就这个本体上说，就是血与气。就作用上来，就是营与卫。就这么个东西，其实是两个东西，不要有四个，它就是气血，在基础上就是气血，就是我们饮食水谷化合物。当然在《灵枢》上讲，也吸收天气了。所以怎么这个气来自于上焦呢，血管吸收了也得到肺，到肺了，他说受之于天。于天，就是指天气。王冰那个注他说先天，搞到肾上去了，不对的，那在生理上也讲不通的。古人也知道这个气的成分，不但有水谷化合物，也有空气的氧气，这与现在讲的生理也没有什么大差别，但是它不够细致，不像西医那么清楚，但知道它的作用。知道它是养人的，作用在血管外头的气的作用叫做卫，在血管内的作用叫做营，古人这么个看法。

那么这一段是说，营卫是相附而行的，一点也不能离开。人如果常出汗，由于卫不和，就是血管外头这个气，不与脉内之营气调和，于是乎，卫自出于脉外，营而自行于脉内。这个卫失去营就不固，就要出汗。营失去卫也不守，也是由里头往外分泌体液，分泌津液，所以才常汗出。归根到底这个毛病在哪呢？是在卫，而不在营，就是卫不与营协调了。

古人说那个协调啊就是血管通透作用，可没明说，说得不像现在西医解剖生理学那么仔细。那么这段呢就说明这些问题，他说为什么常自汗出，他说营气本来是没毛病的，这是外不谐，就是营气外面卫气，不共营气谐和故尔，它本来血管外头水分进血管里头，血管里头的水分也出外头了，我们饮食营养成分都在血管里头，它必须出血管才能营养组织细胞呢。组织细胞的废物呢也得进血管里去才能够排

出，由小便排出，这种液体废物。古人对这个也知道一些，不是一点不知道，但是这个话说的呀非常笼统，不够细腻。那么这就造成什么样呢？营自行于脉中，卫自行于脉外，自行就不行了，不调和了。它在脉外，咱们讲营卫这个阴阳啊，古人讲的很好，他说卫得有营，才能固于外，这个营由于卫外为固，才能守于内，他没说什么血管通透作用，他只是说这个来说明，但是哪个也不能少哪个。如果它们两个不调谐，那就坏了，非出汗不可，这一段就是这么个解释。所以中医就应该参考解剖生理，血管通透作用，那解释得非常细腻、具体，明明这段书说的就是这个，我们要对生理上的情况更细致地了解，我们应该看看解剖生理学。桂枝汤从这段和下段，（可以知道）能调和营卫，他不出汗吗，用桂枝汤再发汗，使营卫协调就好了，桂枝汤起这个作用的。这是头一节，说是“病自汗出者，”就是常自汗出的病，这类的病啊用桂枝汤可以解决的，这是由于卫气不和。

李冠杰：这一条在《康平本》是降一字格排版的条文。

下边我们解读一下：

这一个条文我们分成两部分来解读，一部分是论述方证的；另一部分是论述病理的。

我们先看看论述方证的这一部分，条文里边哪些是论述方证的？

“病常自汗出者、宜桂枝汤”。这就是方证。大家看那些顶格的条文，那些比较精炼的条文里边，那些省文的条文里边，大概就是类似的这么一种论述方式。但是应该有一个条件，在没有其他类型疾病的前提下，这种“常自汗出”的症状也属于桂枝汤证的治疗范畴。这个条文也肯定是作者的临床经验的一个总结，他在临床当中发现了有经常出汗的人，他用桂枝汤治疗效果比较好，然后他总结放到这个地方。对桂枝汤证起到一个补充的作用。因为这一类的情况在别的条文里边没有论述。但是具体到这个条文里边，我们特别要注意的就是跟阳明里热的那种“多汗”要严格地加以区别。要真是阳明里热造成的“常

自汗出”，服桂枝汤的话，那肯定会出乱子，会更加严重。这是第一部分。

第二部分是病理：“此为荣气和，荣气和者，外不谐，以卫气不共荣气谐和故尔，以荣行脉中，卫行脉外，复发其汗，荣卫和则愈”。这是作者对这种病理的理解。

这儿呢有两个概念：一个是“荣气”，一个是“卫气”。“荣气”跟“营气”是通用的。指的是什么呢？指的就是人体内运行于血管内的水谷精气。按今天的话说呢，就是血液和血液所输送的营养成份。卫气，“卫”是指人体卫外的功能。“卫”有保卫，护卫的意思。卫气属于阳气的一种，是“生于水谷，源于脾胃，出于上焦，行于脉外，其性刚悍，运行迅速流利，具有温养卫外，卫护肌表，抗御外邪，滋养腠理，开合汗孔等功能”。这是《中医辞海》的解释。我们搬过来做一个参考。

“常自汗出”，在病理上就是由于“荣卫不和”造成的。还得用桂枝汤发汗解表。实际上整个条文大概就是想说这么个意思。

对“营卫不和”的理解，用现代医学解释的话，也就是血管的通透作用。实际上古人早就已经看到了这个，就是“荣行脉内，卫行脉外”。那么“荣卫不相和谐”，不就是血管的通透作用出现问题了吗？其实在两三千年以前的时候，中国古代人早就想到这个问题了，只是没有今天用显微镜观察了以后，画出一个形象的图表让你看，比较直观。但是现代医学也丝毫没有揭示到事物的本质。血管的通透作用到底通透的是什么，为什么血出不来？那些荣气，现代医学应该叫做营养成分吧，通过肺吸进去的氧气，通过胃肠吸收的营养和水分，不管通过什么样的转化，最终都要通过动脉血管输送到血管的最末端毛细血管，再通过毛细血管的通透作用进入细胞，供每个细胞组织应用。这个过程，实际上现代医学现在还没有能力把它真正地解开，就是说它在血管里边怎么出来的。现在看啊，两三千年以前，古人理解的这些

东西，其实比现代也落后不了多少，说得还是比较深入的。

做一个小结：

对于平素常自汗出的患者，如果没有其他类型疾病的存在，宜用桂枝汤发汗解表。这一类的常自汗出的病理，是由于运行于血管内的荣气和运行于血管外的卫气失去了原有的平衡状态所致。而发汗解表的方法可以使其恢复常态而痊愈。

病人脏无他病、时发热、自汗出而不愈者、此卫气不和也、先其时、发汗则愈、宜桂枝汤、（54）

胡希恕：这个病最常见了。脏无他病，就是指的内脏没有什么特殊的病，拿现在的话说，也不是肝炎，也不是肺炎等等的吧。就是有这么一种证候，“时发热自汗出”。这个“时”呀就是定时，定时发热自汗，那么经久不愈。“而不愈者，此卫气不和也”，这也同上条一样，也由于卫气不和。那先其时发汗，用桂枝汤就可以好的。先其时者，他定时嘛，假设说一天两点钟，下午两点左右，要发热汗出，你在两点钟以前给他吃桂枝汤准好。

这个我遇到很多，也是我一个朋友，他有一个患者是个厨子，二十年，就是这个病，就是到时候发烧，完了出一身汗，过去（以后）像好人一样。他那个时候啊也研究一点中医，他就给他吃这个药，吃了就好了，回头高兴极了，他说这回可好了。这种病，二十年也太多了，这我头一回听说，但是在临床上这种情况很多。有一些人啊老是怕桂枝汤热，其实它不是热，桂枝汤（证），你看看头前，没有一个不发热的，这个也是时发热。要是只汗出不发热，桂枝汤还不行。那么现在呢大家有这么一个毛病，见到热就不敢用桂枝，其实不对的。这个病很多，在临床上很常见的。我在农村也遇到这么一个老太太，每天到 4~5 点钟的时候，必要发烧，然后出汗，出完汗之后，也不

发烧了，也不难受了。她是天天的，也是有很长时间了。这还是在那边我给看的这个病。我给她开三付药，吃了两付药就好了。这个很多，要注意这个。这就说明桂枝汤啊，不止治中风这个病型的表证，就是发热、汗出、恶风、脉缓，它也能调协营卫。调理营卫，营卫不和呀，他举这么两个例子，一个，常自汗出，第二个，时发热自汗出。这两种情况全是营卫不协、营卫不调，那么这个书说是卫不和。桂枝汤专调营卫，治这种病的。那么用药的方法呢？他那个不定时那个没办法了，那还是根据一般，早晚吃了。他这个有定时这个，在发作以前两个小时最好，给他吃就可以好的。

因为这个地方你们回头看看咱们讲那个桂枝麻黄各半汤，桂枝二麻黄一汤，为什么里头搁桂枝汤呢？就是“形如疟，日再发”，就是定时发寒热，不汗出，所以不是整个桂枝汤（证），不是只是营卫不调，还有因为不得汗出，所以他用麻黄桂枝各半汤，我们讲那个时候啊就引证这一条了。讲到这个地方，回头再看看，对于那条也就明白了，为什么用麻黄桂枝各半汤，桂枝二麻黄一汤，全是由于桂枝汤这个药能治定时发热而汗出，可以回头看一看。

李冠杰：这一条在《康平本》里是降两字格的条文。

下边我们解读一下：

“病人脏无它病”。看看全书，明确以脏腑来论述疾病的在顶格条文里边非常少，实际上整个书上也不是很多，包括王叔和写的这些条文都不是很多。实际上这是有意识回避脏腑。我一直持这么一个观点：经方理论学派也肯定走过脏腑辨证这条路，后来发现走不通，跟临床实践不能相吻合，特别是跟经方这一套东西不能相吻合，后来它就抛弃了脏腑辨证。到后来成熟期的作品，就是看到的《伤寒论》、《金匱要略》里边真正论脏腑的很少，尽管王叔和加了一些，但还是很难找到具体的地方是真正用脏腑来辨证的，没有。实际上这是有意的回避。这在当时是一部医学上的专著，而且是巨著，这么重要的一

部医学专著，论述人体生理病理药理这么广泛的内容，却恰恰没有论述脏腑，而且在五六百年以前的《内经》里已经把脏腑了解得非常的到位了，包括具体的尺寸、形状、作用，在人体当中的一些特性什么的都该有了。它的论述只能这么去理解，是有意的回避，因为那个跟临床不吻合。我经常举那个例子：两个肝炎病人，一个用小柴胡汤治好了，一个用吴茱萸汤治好了，这是两种不同性质的肝炎，根本就不是一个病，是人体在两种疾病的人体内环境下，在相同的部位发生的相同性质的疾病（西医诊断命名的疾病）。实际从根本上说它就不是一种病。那么“脏无他病”这肯定明显的就有了脏腑辨证的意味。

这条的“脏无他病”应该怎么去理解？用经方的理论来理解，不妨把它理解成既没有里证也没有半表半里证。这样跟它这个意思相吻合的，它所说的脏腑，恐怕也就涉及到里和半表半里的几率多一些。

“时发热、自汗出而不愈者”，这儿说的是桂枝汤的一个特殊证候。就跟刚才那个条文有相似的地方，也是做了一个补充。说除了桂枝汤条文里边论述到的那些典型的症状范畴之外，还有这一类证候可以用桂枝汤啊治。“时发热”是什么意思呢？古人用字比较精炼，“时发热”用今天的话说就是每天在固定的时间里发热。等把全文全学了你就会明白，应该这么理解。“自汗出”具体是指的什么呀？先发热，然后就是汗出，这就成了一个症状，发热就是发烧体温高，体温升高了以后就出一些汗。后边“而不愈者”在这个地方作用还不小，不是说出完汗以后还在发热一直不愈，如果那样子的话，时汗出就不是那个意思了。为什么会说是汗出呢？就是因为每天这个时候都会发热出汗，然后第二天又反复这个过程，所以就来了个“而不愈者”，老是好不了。像这一类的疾病在临床中为数不很多，但确确实实有。像胡老的讲座里边，郝万山的讲座里边都提到了这样的医案。说明条文所论述的情况直到现在依然可在临床当中得到验证。

下边“此卫气不和也”，这是对病理的解释，也没有什么特殊的，

前边第 53 条里已经比它论述的还要详细，是一个意思。

“先其时发汗则愈”，这是说的一个治疗方法。那不是定时发热吗？“先其时”就是在它发热之前发汗则愈。“发汗则愈”是让他喝发汗药，喝什么样的发汗药？后边说了“宜桂枝汤”，就是喝桂枝汤。

这个第 54 条在全书来看，它在降两字格的条文里是比较精的一条，一是论述的比较精炼，再一个是它能经得起临床的验证，能和临床接轨。这一条跟前边的第 53 条对桂枝汤证进行了非常有益的补充，列举的都不是一些重复的问题，而是顶格的经典条文里没有论述到的。就是说桂枝汤证的两种比较特殊的情况。

下边做一个小结：病人平时没有明显的疾病证候，但是每天都会在特定的时间段内出现发热，而后汗自出，过后便会自行消失，这是卫气不和造成的，需要在发热之前发汗就能痊愈，宜用桂枝汤治疗。

伤寒脉浮紧、不发汗、因到衄者、麻黄汤主之、（55）

胡希恕：这同上边啊，“伤寒脉浮紧，发热无汗，自衄者愈”那一条可以对照着看。那么伤寒脉浮紧，这是表实证，应该发汗，就由于不发汗而致衄，那么这个血管充血达到一个相当程度，他非要破鼻子不可。那么这个致衄也有好病的，头前那条就是的。要是不好呢？该吃麻黄汤还得吃麻黄汤，这个就是，这个就补充那条的不足了，那条这不是在这呢“太阳病，脉浮紧，发热，身无汗，自衄者愈”。

这不是个绝对的，我方才讲也这么讲的，所以“脉浮紧、发热身无汗”，这种表实证，有人需自衄而愈的，那么这一段呢，就是也有不愈的，就由于你不发汗，那么他这个充血是越来越盛，里头就阳气重了，越不发汗，阳气越重，重到一个相当的程度，他就要自衄，这由于不发汗所致呀。那么这个时候啊，病虽然衄而不自愈，你还要用麻黄汤治疗。这两节你一看就明白了。所以，它不是固定的，这个病

它是瞬息万变的，有因衄就好的，有因衄不好怎么办呢？该治还得治。这个就是补充那条。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边是一个顶格条文。“因到衄者”在《宋本》里边为“因致衄者”，这个没有严格的区别，但是它确实有一个字的差别。

解读一下：“伤寒脉浮紧”，这是太阳表实证，而且这不仅仅有伤寒这个定义，同时还有一个典型的症状就是脉浮紧，这是一种简述的方式，就是想跟你说这是一个典型的太阳表实证，它还可能存在太阳表实证其他的症状。后边条文里边有好多冠以伤寒，但是大概仅有一两个症状，近似于伤寒，也就说有伤寒的那种外观，但是那绝对不是伤寒病。这个地方就等于说是里边还涵盖了太阳表实证的诸多症状。

“不发汗”，从字面上来看就是说没有治疗，但是也不排除有用其他的方法治疗的这种可能性，比如像误治啊，或者辨证错误用一些不是发汗的方法。用了别的方法也不见效，比如麻黄汤证，你让他吃小柴胡汤，它不会有多大的副作用，它可能不会添乱，但是病可好不了啊，因为它治不到点子上，它还会慢慢加重，也许就会出现这种情况。

“因到衄者”就是因为失治或者治疗不当，造成病情反倒是越来越重，一直到了衄血的这种程度，也就是到了破鼻子这种程度。咱们在学习第 46 条的时候对这个衄血的机理做了比较详细的解释，实际上这个地方是一样的。

条文里边最后给你的解决办法是什么？“麻黄汤主之”。这里边就有问题了，前边那个顶格条文以外的作者一再补充这个事，等于说我见过表实证鼻子破了以后就好的，但是这个地方他却论述了没有好的，经典的东西它就是经得起推敲，你看这顶格条文没有直面地去论述衄血以后好了的情况。其实也等于说因为他好了，你不用治了。再

看别的条文，也有论述类似的这类问题，真正要是没有症状了，你就不要治了。

这个地方论述的是鼻衄了以后表实证并没有解除的情况，这点很重要，要不然跟其他的条文发生矛盾了，那说鼻衄了以后表就解了，为什么还麻黄汤主之啊？这是说鼻衄以后有的人能好了，有的人好不了，他还是表实证的症状，比如发烧，鼻血流完了以后烧也没退，还是那些症状，可能程度稍微轻一点，但是没有质的变化，这里就示意读者，你还得用麻黄汤来治。

下边做一个小结：太阳伤寒表现为脉浮紧等典型的表实证的症状反映，因未能及时治疗，或者未得到正确的治疗，而发生了鼻衄症状的，如果表实证仍在的，为麻黄汤主治之证。

伤寒不大便六七日、头痛在热者、与承气汤、其小便清者、知不在里、仍在表也、当须发汗、若头痛者必衄、宜桂枝汤、（56）

胡希恕：那么这个头痛有热是表里共有的病，太阳病也有头痛发热，阳明病也有的，那么这个，他说这个原起是伤寒啊，就是表实证啊，就是无汗这种伤寒，已经不大便六七天了，那么这个头痛有热呀，大概就是里实的问题了。这个久不大便啊，它就造成自己中毒啊。我们饮食入胃，血管要吸收，可是老不大便，你再吸收了，就是有了毒素它也吸收，所以生理上就这个样子，它不知道有毒没毒啊，所以日久不大便容易有头痛的。他这六七天不大便啊，那么头痛有热，按着常规上看，这是里实证，与承气汤。这个“与承气汤”，他也不是说“主之”啊。他这个书啊，“主之”就是固定不移的。“与之”，比这个“宜”的口气更轻，“宜”就是当，应当，也不是“主之”。这个“与”是大有商量余地的，“与承气汤”，这个承气汤也多种啊，

大小承气汤，调胃承气汤等等的吧，可以与承气汤，就是你根据他这个病情的轻重缓急，斟酌着用吧，它是这个意思。假若真是里有热，那个小便呀它要红赤的，这个是很要紧的，这是辨证的法子了。

那么这个头痛有热，不但阳明病有，太阳病也有。那么如果阳明病，他里热，里热了小便红赤。那么“小便清者”，色不变，“知不在里，仍在表”啊。那么这个虽然六七天不大便，你不要光看这个不大便，这还是表证，它要是阳明病，小便绝对变色。“当需发汗”，那么这个呀你还是要发汗的。就是这个病啊有疑似之间，我们找这个特别的鉴别的一种方法，尤其这个表热里热鉴别的方法以小便是最好辨了，所以咱们在临床上要问，不问不行。

那么这个表热里热，最容易辨的莫过于小便，你问问小便怎么样，小便一点颜色也不变的，里头没有热，你别给人吃承气汤了，这还仍在表，当须发汗。这个发汗，可能它是麻黄汤，他说的是发汗，而且开始他用的是伤寒，没有汗。“若头痛者，必衄”。他这个一句话差不多就是一段的意思了。假若吃过麻黄汤发汗，而头痛不已，那个人啊他必衄，什么道理呢？这个就是病深，他在六七天，他这个病啊，这个热病都往上冲，六七天发汗之后还不好，脑袋还疼，说明这个上冲也厉害，这个上冲是桂枝的主要的证候，所以治头痛啊，这个麻黄汤不如桂枝汤，可是麻黄汤也有桂枝，但是桂枝量也小，所以一般的头痛啊大概（用）桂枝汤的多。他说无汗，你不能吃桂枝汤，先要吃麻黄汤，可吃了，头痛还仍然不好，那个就是与桂枝证上冲有关，不但头不好，而且必衄。“宜桂枝汤”，那么这个时候啊应该用桂枝汤，再小发汗就好了。这也挺重要，重要在哪呢？就在这个验其小便以知表里，这个汗下异法呀，这个很重要，该发汗的吃泻药不行，那么真正阳明病发汗也不行啊，越发汗，里头热结得越厉害。那么假若发汗，不好，脑袋疼得厉害，鼻子出血，你以为解表解错了，也不是的。那是因为久不得汗出，阳气重一方面，同时气冲得也厉害，气往上冲，

这时候你再更发汗，这个表还是没解嘛。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边是降两字格排版的条文。

这个“头痛在热”，《宋本》是“头痛有热”，恐怕是传抄过程当中抄错了，因为“有”和“在”如果说出现残简或者说出现虫蛀之类的就容易认错了，可能会出现这种情况。

下边解读一下：

“伤寒不大便六七日”，伤寒，已经界定了至少有太阳表实证的某些基本特征。你得往里边看有没有别的情况？实际上咱们辨证也就这样。这个人感冒了，最起码你得看看他是表实证还是表虚证，同时他有没有水证，有没有半表半里证，这是最起码的。这儿说的呢，是有伤寒的某些基本特征，但是大便已经多日不通了，是这么一种情况。

“头痛有热”，这个“有热”就比较含蓄了。他是体温高还是有内热的表现？在这儿应该理解为体温高，因为他后边有一个辨证的方法。所以“头痛有热”，就是既发烧又头痛，再加上大便好几天都已经不通了。这种情况通常是阳明里热的情况比较多，所以“与承气汤”。

但是他后边的条文的意思呢？“头痛有热”，太阳表实证，头痛、发热是完全有可能的，脉浮大也是有可能的。像这种情况如果他要是表为主那就不行了，这就需要进行一个辨别。

那么怎么辨别呢？如果病人小便清，就知病不在里，仍然在表，还需要用发汗的方法治疗。用小便来判断有无里热，应该是临床当中一个常识，在临床当中常用。小便黄赤，常常是里热的一个很重要的征象。虽然小便黄是确定里热的一个重要的方法，但是也不是唯一的方法。这个地方，只是作为一个典型的鉴别点，来跟大家举的这么一个例子。

“小便清”指的就是小便的色泽正常，也不是像清水一样，可能微微有一点点发黄，这说明没有里热存在，这都是些常识性的东西。表证的人，如果一整天不喝水，他也会出现小便黄，但是跟里热在程

度上都会有区别，你稍微问一问就知道。有多长时间没有喝水啦？你平时喝水多吗？都能问出来。当然这是一个很重要的鉴别点。

“知不在里仍在表”，这就是示人表里之辨。揭示辨证的过程当中，辨表辨里相当重要。只有把那些东西辨清了，才能去对照经方的治疗原则，才能去最终确定方证。

“当须发汗”，已经确定了病人的病还是表证，就得用发汗的方法来治疗。这个地方也说得非常准确，就是“当须发汗”。虽然这个地方还没有涉及到具体方剂，我们应该理解他就是指的麻黄汤。因为他前面说了是伤寒，而且表现出来的症状也都是麻黄汤治疗的范畴。

在这个地方啊，延伸一个问题，就是阳明里热。这个小便黄赤的病理机制是什么？实际上就是内脏的各个组织器官处于一种病态的亢奋状态，使得人体整体的代谢加快，产生的代谢物就相应的增加，再加上有里热，还有一部分水份通过体表散发出去，这样呢，体内的水份浓度就更高了。尿液中代谢物浓度高而水分相对少，就会呈现一种黄色褐色，甚至黄赤。

“若头痛者必衄，宜桂枝汤”。我们把它存疑，仅做一个参考。严格地分析它是有问题的。

这个条文跟第 46 条的情况，除了大便不通之外，其他的基本上接近。第 46 条是太阳病，脉浮紧、无汗、发热、身疼痛，这不是一个太阳表实证吗？八九日不解，表证还在。再看看这一条论述的病理阶段和状态跟那一条非常相似，这里就多了一个大便不通。他就让你跟阳明病去鉴别。但是他这儿最后来了一句，头疼者必衄，还要用桂枝汤来治。

那么这个地方，我们分析有这么几种可能性。一个是，如果发汗后表仍然不解又出现鼻衄了，就是 46 条讨论的情况，还得用麻黄汤。还有另外一种可能，就是发汗以后没有好，46 条不是也说吗，服了药以后微除嘛，因为病很重发了汗以后还没有好，出现鼻衄的话，不

还是麻黄汤治吗？如果发汗过了，成了表虚证，这倒是桂枝汤治的，应该用桂枝汤来治了。但是一旦要成了表虚证的话，绝无鼻衄的可能。为什么？因为它不是那种病理了。所以最后一句话，我们就存疑。

如果临床当中真的碰到鼻衄的话，鼻衄是表虚还是表实的情况下？如果是表实的情况下，就得用麻黄汤。如果真是表虚，一直有汗出，又没有别的什么症，其实用桂枝汤也没有什么不好的。

这个条文真正的有价值之处在哪？它给我们示范了辨证方法，我们可以在他这种示范的基础上举一反三。在辨证的过程当中，去鉴别不同类型的疾病，还是要看症状。这一条里边就说的又具体又生动。比如头疼、发热这一类的症状太阳病有，既是太阳病的疾病反应症状，也是阳明里热的疾病反应症状。如果有大便不通的话，那么阳明里热的可能性就很大了。你要是想进一步鉴别的话，看看他的小便，其实其他的也完全可以，不仅仅是小便。比如说舌质、舌苔，包括病人的自我感觉等等，很多方面都能够佐证。

下边呢做一个小结：

症状反应很像太阳伤寒，但是已不大便六七天的时间，如果以头痛，而且发热为主要证候，则可考虑以承气汤类方剂来治疗。患者如果小便清长，说明没有阳明里热证，病仍然停留在表实证的阶段，应该以发汗的方法治疗。如果发汗后仍头痛者，则可能出现鼻衄的情况。

这一条，辨证要素里头涉及到了好几个点。一个是表证；再一个就是里证。具体到里热证，那是不是表热证呢？大家是不是想到这个问题了。那么如果病还在表的话，这个表证是热证还是寒证，咱们也讨论一下。

首先我们从解表方剂上来看，表证只可分虚实阴阳，没有寒热。我是经过反复的推敲核实，我一般情况下不敢轻易下这样的结论。我经过反复地去推敲这个事儿，最终我就觉得这样比较符合事物本来的

面目。也就是说表证只分虚实、阴阳，没有寒热。

为什么这么说呢？我们看方剂，因为经方的基础就是方证啊，方子和症状。麻黄汤证，桂枝汤证都有发热。人们就常说：甘温除大热，就是说这是表热证。但是表热证用的几乎全是温药，这就跟治疗原则不能合拍了，这是一种情况。

再一个，理中汤证有时候也会出现发热。人得了胃炎拉肚子，但是还发烧。那么这个时候治的是什么呢？治的是里虚寒。虽然他有发热，但是还是治的里虚寒。

再来看白虎汤证，白虎汤证有时候人会出现四肢厥逆，浑身发冷，就体温降低的这种情况，就是说比较危重。但是治的是什么呢？它治的却是里热。

再看看表阴证，桂枝加附子汤证，麻黄附子细辛汤证等等，也有发烧，这一类的发烧，用的药就更温了。重点是加的附子，附子实际上对的是什么呢？对的是人体机能的沉衰和里虚寒的存在，停饮的存在。

那么这个地方应该怎么理解呢？到底是一个什么性质的问题呢？实际上从人体的功能这个角度来看，表寒表热不是人体疾病的主要矛盾。人体疾病的主要矛盾在哪呢？在里和半表半里。而且我们从治疗上，刚才从讨论的治疗上大家也明显地能看出来，这个表的体温的高低对治疗没有质的影响。你像白虎汤证，他体温低了，他有真正的里热，你也得让他吃大寒的药，也得让他喝白虎汤。如果从这个角度看，大家想想，我现在只是跟大家提出这个问题。这是我的这么一个看法，表证无寒热。换句话说，表证的寒热对治疗没有实质的影响，只是站在治疗的角度。如果从疾病反应来说，他有寒热的，有时候表现发烧，有的体温高，有的体温不高，确确实实有这方面的情况。但是，对治疗形不成质的影响。实际上从人体来说，肌表和内脏相比较的话，重要程度不同。

伤寒发汗已解、半日许复烦、脉浮数者、可更发汗、宜桂枝汤、（57）

胡希恕：这个他就接着上边一节，怎么头痛者必衄，完了就得吃桂枝汤呢？这也是定法。这个头前我们讲过了。本来他是太阳伤寒，发汗已解，但是半日许呢复烦，他这个表解了人就不烦了，烦就是有热才烦呢，还是热没除，他又烦，这时候你看他脉啊还浮数，还是表热呢，可更发汗，这个时候啊再发汗就好了，但是不能用麻黄汤了，宜桂枝汤。

这就是说，我们讲了这些，全是对于麻黄（汤）桂枝（汤）这两个方剂应用方面反复地来申明。他说麻黄汤吃过之后，如果病不解，这个病还在表，那你还得解表，还得发汗，但是不能再用麻黄汤了，必须用桂枝汤，在这他特别地郑重其事地点出来，头前都没说明啊，可是我讲了。那么上边那个也是，本来他是头痛有热，小便清这是表证，可是他是伤寒，没有汗的病，当然先用麻黄汤。可是使麻黄汤也对呀，但是头痛不好，鼻子反倒出血，那么这个时候脉当然也还是浮数的，你再吃桂枝汤就行了。这是定法，这在临床上也是一样的，这个麻黄汤不能连续用，凡服过麻黄汤而表不解，你再解表就得用桂枝汤。你服过桂枝汤表不解，不能用麻黄汤，还得使桂枝汤。这是定法，所以桂枝汤这个药啊最平和不过的，绝不象后世这个说法，他就用一句话了，“桂枝下咽，阳盛则毙”，那正说明麻黄汤证，这个头前有了，说桂枝本为解肌嘛，若脉浮紧，发热无汗，这种太阳伤寒病不可与之也，常须识此，勿令误也。

我们上边方才讲这个，阳气重的这种病，阳盛则毙就是指阳气盛，他这个表实证，不得汗出。这个桂枝汤怎么个药呢？桂枝汤，它是甘温，虽然解表，有益胃生液的这么一种作用。他已经是体液充实

体表了，你还增液，你还让他，实上加实了嘛。所以这个麻黄汤证用桂枝汤是绝对不行的，这个阳盛指着阳气盛于表那个阳盛，不是有热，桂枝汤（麻黄汤）哪个不治热病啊，都治热。后世给曲解了，凡是热就不能吃桂枝，这都是错的。桂枝汤这个药啊非常平稳的药啊，我常用，那就是伏天我也用，也是三四钱这么用，怎么也不怎么的，哪有那么回事呀，该用你就得用，不该用你非要用那也不行啊，那么这是一种定法。他说伤寒发汗，本来是药对证了，吃了也好了，可是半日过它又来了，脉还浮数，还在表，你就换个发汗的法子，用桂枝汤就好了，不能用麻黄汤。

李冠杰：这条在《康平本》是降一字格排版的条文。

下边我们解读：

“伤寒发汗已解”，我们可以把它简单的理解成就是太阳表实证，服过了发汗药以后症状基本消失了，它的治疗也是正确的，也起到了应有的作用。

“半日许复烦”，过了半天的时间病人又开始不舒服了。“复烦”又开始不舒服了。

“脉浮数者”，这是列举的典型的一个症状。实际上“脉浮数”它本身是一个很简单的问题，是说脉浮在这个地方。因为本来得的是表证，吃了解表药以后又出现了这样的情况，说明前边没好利索，也说明病情相对比较严重，虽然治疗的正确，但是没有根除。“脉浮数”，我们别把它单纯地看做是得有这个脉象，实际上它的背后的意义就是说病没有全好，也在告诫你别以为是又得了别的病了。太阳病的前几条不是“或已发热，或未发热”，脉不也是“脉数急”吗？这是人体在抗病的一种反应。“脉浮数”，或许已经开始发热了，或许是一个发热前的前驱症状，它“浮”在表，“数”实际上这个时候已经要发热了，或者已经开始发热了，体温开始高了。

列举这个脉象是什么意思呢？比如说吃了麻黄汤，出了汗感觉轻

松多了，过了半天以后又觉得开始不舒服，这个时候你摸摸脉，尽管可能还没有发热，但是脉跳得很快，而且又浮，浮就在表嘛！实际上是说病尽管治疗正确但没有全好，应该用桂枝汤再发汗，后边跟的是“可更发汗”嘛。

这里交代了一个非常重要的治疗原则。因为病人已经发过汗了，或者用现在的一句土话说汗已经出透了，而且病也好了那么一阵儿，如果再出现反复的话，这个时候就应该用桂枝汤了。因为它处在一种表虚证的状态，用现在话说就是汗腺孔已经打开了，在这种情况下，就算是有像脉数，也许再过两个小时以后就开始发烧了。那么发烧、头痛，甚至包括身疼痛，你也不要以为是个表实证的，不能当表实证来治，应该用桂枝汤来治疗。这是一个很重要的治疗原则：发过汗以后或泻下以后都必须应用桂枝汤，不能用麻黄汤了。

下边做一个小结：伤寒病，经发汗治疗后，症状已基本消失，但是过了半天左右的时间，患者又出现烦的症状，同时表现为脉浮数的，还应该用发汗的方法来治疗，宜用桂枝汤。

凡病若发汗、若吐、若下、若亡津液、如此者、阴阳自和则必自愈、（58）

胡希恕：这一下就是发汗不合法，也造成很多的问题。他这个是个泛论，无论什么病，我们治疗啊汗、吐、下这是一个攻实去病的一个大法，在中医上说，汗吐下都是攻实去病，可是用不得当，都足以害人，起码是亡血、亡津液。这个亡血就是亡血液。亡失血液，亡失津液。那么这个汗法，发汗最亡失体液得厉害。那么这个吐下也是一样的，他本来吃些东西，胃消化之后要吸收的，你不等他消化，不等他吸收，都吃泻药下去了，身上体液也是不能够补益，不能够继续得

到吸收，也是少了嘛，也亡津液亡血液嘛。

如果阴阳自和，阴阳自和指着表里，表里没有他病，我们经过发汗，或者吐、或者下，损失了血液和津液，如果表里自和，这不要紧，这个病可以治好的，不必乱治，“必自愈”。那么言外之意，津液血液亡失，而又有表里不和的现象发生呢？那你得治疗，没有（不和）不要紧的。所以人的这个身体呀也不是一下子就能糟蹋坏的，但是这个是不合法的发汗吐下，损失人的津液体液，亡津液亡血液这是肯定的。亡就是亡失的亡啊。

李冠杰：这个条文跟《宋本》的同条出入比较大。《宋本》的条文：“凡病，若发汗，若吐，若下，若亡血，亡津液，阴阳自和者，必自愈。”如果比较一下，你明显能看出来，《宋本》的条文是对《康平本》条文的一种修正，一种润色。比如《康平本》里边“如此者”，就有点没什么意义，反倒不如《宋本》的把“亡津液”又加了一个“亡血”，从道理上很直观，相对全面一点。“阴阳自和者必自愈”，语言也比较流畅，明显地看是经过润色以后经过修改的。这应该是王叔和二次整理《伤寒论》的一个证据。这个条文在《康平本》里是降一字格的条文。

下面我们解读一下：

“凡病”在这个地方是一种泛论，它泛指一切疾病而言。古人写东西比较简一些，那也不能说是所有的疾病全都概括在里面，就是说在大多数情况下，也不管你是得的是表证，还是里证，还是半表半里证，如果用土办法治疗，或者用汗法治疗，或者用泻下法治疗，这些方法大家看，没有补虚的办法，全都是攻法。凡是这样的攻法有一个共同的特点，如果用之得当可以愈病，用之不当就能伤人。如果进一步说的话，就算是你用之得当，比如这个人是个调胃承气汤证，给他调胃承气汤往往吃上一两剂就好了，再接着吃就不行了，就到了要么出别的变证，要么人体到了难受的时候了。所以说这都是些攻法。

“若亡津液”，《宋本》里是“若亡血”，实际上是一回事呀。因为这个条文前面，它论述的对象是“凡病”，指的面相当宽，这个地方为什么要写上这个呢？刚才我们说了，你要用得对的话，就是攻法也不会伤人的，这些个攻法在好多病里面是合适的、是正治。但我说的不是那意思，后面就给你加了一个进一步的说明，避免你会想到那上面去，避免你理解这里面可能包括正治，我强调的不是那个。所以特别给你说，汗吐下之后，又亡血，又亡津液的，就是说已经伤了人了。

“阴阳自和则必自愈”。这个“阴阳自和”是什么意思？这不是单纯指的脉象的问题，我们可以把他笼统的理解为没有明显的疾病反应了，人显得非常平和了。如果出现这种情况，换句话说他没有明显的病症，他就会自愈了，“必自愈”嘛。

这个“必自愈”本身就包含了两层意思：一层意思就是这个病可以自愈，这论述的是误治以后也能愈病的一种特殊情况。如果每次误治都能病愈的话那就没必要作这种论述了，这本书也就没有用了。

第二层意思就是，一旦你给他用了攻法，治疗了以后他反倒是没有疾病反应了，人还感觉挺平和挺好的，这种情况下就不要再治了，不要妄加治疗了。

历代对这个条文的解读，都有些或左或右的出入。大部分都是刚才我强调的这个问题，说这里论述的是经过正确的治疗以后出现了阴阳自和，这么解释的不是一个人，好多，你可以去翻一翻书。因为他们从病理上想不通，为什么误治还会愈病，而且都是些攻法，在临床当中他又没有经历过，那么怎么办呢？他就曲解。但是他不想想如果是正治可以好病的话，后头的阴阳自和必自愈这句话还有什么意义？

举个例子，比如这个人得的是大承气汤证，让他喝了大承气汤病就好了，这本身就是意料之中的事，合情合理的事，根本就不存在“阴

阳自和必自愈”的问题。这不废话吗？人家不是说的这个意思，他肯定得有他的道理。既然是这样肯定，最起码他在临床当中不止一次地遇到过这种情况，我们后面再作一个讨论。

我们先作一个小结：凡疾病，如果使用发汗或涌吐或泻下的等攻的方法治疗，都会损失人身的津液和血液，如果人体出现的所有症状都基本消失的这种情况，可自行痊愈，不必再妄加治疗。这是这个条文大致的意思。现在再提出前面的问题来，为什么误治反倒是可以愈病，反倒可以把病治好了呢？

我在这跟大家等于说是借题发挥。我们在这一条不讨论这个问题的话，在其他条文讨论就不太合适了。这是一个很重要的而且现代医学还没有这个概念的。

这么一个可以被临床实践证明是正确的一套东西，就是这个第58条，如果你按正确治疗的话，首先就带出一个问题来，逻辑上讲不通，误治了而且又明明地给你说的很清楚，伤着人了。为什么病还会能好？咱们现在先从一个很特殊的情况说起，心理学家作过这样的调查，专门去调查那些死过一次又活过来的人，比如交通事故，比如休克过了以后或者不管有什么特殊的病症或者经历的，就是说他死过一次，死了一两个小时或者说十几分钟，后来又经过抢救或者什么他又过来了。人临死的时候他在想些什么？他是个什么样的感觉？他们去找各式各样的人去走访。最后得出来的结论让人惊讶，所有死过一次的人都说，临死以前的感觉就是上天堂的感觉，浑身有一种轻松感，很舒服，不知不觉就过去了。这是大多数人几乎都在说这个，这是一个很奇特的情况。

大家都会认为死是个很痛苦的事，而真正死过的人反倒是会说出这样的情况来。我们再说一个情况比他们更轻一点的，回光返照，这个我们在临床当中常见。长期卧床不起的危重病人在临终之前几个小时之内，他会出现回光返照，突然清醒了，脸色也很好，精神也很好，

人也很明白，甚至他就开始要吃的，这个时候没有经验的家属，以为是不是要好了，有经验的医生知道这个人快不行了，所以这种情况出现多了，给他起了一个名字叫回光返照。这和刚才假死以后的人的那种感觉，实际上是在不同的层面出现的相同的问题。

这是什么问题呀？这是人体彻底放弃与疾病的抗争了。我从小身体比较弱，自己慢慢调的身体一天比一天好，一直到现在，我大概有一年多了不知道鼻子不透气是什么感觉，没感冒过，但是这样我是不是每天都特舒服呀？不是，也会今天觉得这有点不舒服，这会儿那还有点不舒服。但是返回去想想以前身体不好的时候，十年以前甚至二十年以前刚参加工作的时候，曾经到过什么样？晚上躺那睡不着一下到下半夜的三点才能睡着，大家想那种失眠相当得痛苦，我跟他们开玩笑，说房间里面有几个蚊子，飞的是什么样的动静我都知道。现在如果再想想以前那种体质呀就没法想了，就是说现在最不行时候比那时最好的时候也要好多了。就跟抽烟一样，平时吸 5 块钱一包的，后来换成 10 块钱一包的烟，你会觉得这烟比 5 块钱的好多了，你抽上三五个月以后，你一点也不觉得它好了，但是要返回去抽 5 块钱的烟那你不行了，这东西能抽吗？道理是一样的，都是相比较而言。

但人体是另外一种情况，人活着的时候他在不停地调整自己，去适应环境，去调整自身的内环境的平衡，在这个调整的过程当中，总是有这样那样的一点点不舒服，人其实上就是这样的活着。但是一旦不去调整了，把所有的能量都去濡养你的精神，你会短时间的出现非常舒服的一种感觉，这就有点像毒品，服了以后为什么人会那么的亢奋呀？它阻断你的神经让你感觉不到你身上的那些痛苦了，有的毒品就近似于麻醉剂了。

从这个意义上深入去看，就说现在社会上存在着大量的抗生素治感冒，因为这个事太明确了，人家抗生素的发明者明文给你说“抗生

素不能治感冒”，国外绝对禁止用抗生素治感冒，实际上我们国内也不允许用抗生素治感冒，但是临床当中却比比皆是，都用抗生素，用抗生素治感冒的。

它确实能治吗？怎么治的呢？如果不用抗生素的副作用反倒是没法解释了，实际上是用抗生素的作用把人体的抵抗力降下来了，人体不去抗那个病了，把人体肌表抗病的能力给收回了，没有那个能力了。用抗生素把它（那个副作用换句话说就是毒）毒害的没有那个能力了，看起来好像没有这部分疾病了。

到这儿大家就容易理解，为什么用攻伐的方法反倒是有时候能愈病，看抗生素治感冒你就明白了。有个有意思的事儿，美国的孟山都公司，中国人恐怕 96%的人不知道梦山都公司是个什么样的公司？但是很多人都在用他的产品，从小就用，糖精就是这类公司生产的产品。这类的公司专门出这种东西，就是说打擦边球，说它的东西是毒品也不能说它是，但是副作用很大，而且还让你有依赖感。像糖精到现在恐怕还有人在用，对人肯定是很不好了，但是它甜啊。所以这种公司很低调，从不做宣传，用户不知道，但是它这里边利益牵扯到，它有市场就能卖啊，它也不告诉你真相，而且利润还很高。低调是因为说得不好听点，就是不光彩。

但是抗生素在医学里面瞒是瞒不过去的，都知这个副作用大，国外拿抗生素跟杜冷丁一样对待，不管多重的病，要是需要用抗生素的话，必须得经过院长签字。唉，不知怎的慢慢地形成了社会上都在用抗生素治感冒呢？这里面的原因其实很值得分析。可是从技术的角度来说，它能通过降低你的抵抗力，把你的感冒症状消失了，而不致于让你出现其他的病症，这一点比中药还高明。

大家想想，你要是用别说是大承气汤了，小承气汤你治个感冒试试，非把人泻坏了不可。偶尔会遇到病人吃了一次，拉了两次，拉了二次感冒症状好了，可能会出现这种情况啊，这个条文里面论的就是

这个。可是不能老用这种办法，不一定多少病人里头你能碰上一个。但是抗生素类几乎是 100%，也不是 100%，好多体质比较好的孩子，输了有时候说好像有反应，输得严重的，有的还得败血症的。

这一条有着特殊的意义，我们应该去深入地去理解，把条文理解好了以后，你可以举一反三的迎刃解决好多问题。这是第 58 条。

如果按《宋本》的顺序，接下来学习的是第 59 条，实际在《康平本》上，第 59 条、60 条、第 61 条这三条在第 80 条中，是第 80 条的其中的内容。显然这是在整理的时候把它给挪过来的，咱们一直在关注着《康平本》和《宋本》的区别，这个地方是很重要的一个点。我一直在跟大家强调，从《宋本》和《康平本》的区别上，我们能够明显地看出来，后人对《伤寒论》这本书的态度是非常严谨的，包括一些错字都保留下来了，像这么整段的文字把它给调整位置，这种情况，根据我们现在知道的史料来看，恐怕只有一种可能性，那就是王叔和做了第二次的整理。这个观点呢我是说了好几次了，形成这个观点是我在校对的过程当中逐渐地认识到的，我以前压根就没有这种概念，历史上也没有任何人这样解释过，根本就没有这一说。但是我在整理的过程当中，这些问题它得有一个着落，为什么会出现这种情况？第 80 条里边的一部分内容为什么挪到第 58 条下边去？从内容上来看好理解，他是把相同类似的条文集中到一块了，都是太阳病误治以后的。但问题是谁做这样的事儿，谁可能会做这样的事儿？根据我们现在知道的情况，只有王叔和。而且是他在第二次整理的时候。如果他是一开始就这样的话，我们看到的《康平本》就应该是这个样子。所以说他第一遍整理了《康平本》，后来觉得不尽兴又整理了第二遍。第一遍的时候加上了《伤寒例》，整理第二遍的时候又加上了他的那个《平脉辨脉》，后边还有，就是那个《辨可与不可》。应该说整理本身也是有收获的，经过第一次整理完了以后，和临床体悟，后来又发现了有好多他自己觉得不尽兴的地方，觉得不到位，又进行

了第二次整理。在第二次整理的时候他把这三条条文，也就是把 80 条里边的一部分内容调整到了第 58 条的后面，就形成了《宋本》这种情况。这种解释最合情合理，要不然你没法去解释。《宋本》我们现在可以把它叫做官方本，因为这是经过宋代的校正医书局校正过了，而且宋代那时离汉代也不说特别远，所以说能够明显地看出来，后人对这些文字内容是相当相当得严谨，能做这样调整的，后人是没有做的，只有一个可能性就是王叔和，他做了这样的调整。

关于这三条呢等我们学到 80 条的时候，就一并把它给学习了。

发汗后、身疼痛、脉沉迟者、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主之、（62）

胡希恕：这个在《玉函经》上没有分量，也没有新加两个字，就是桂枝加芍药生姜人参汤，这本书搁上这个也没有什么大问题的，都可以通。“发汗后，身疼痛”，身疼痛是表证了，那么发汗之后，身还疼痛，那么表没解呀。表未解，依法应该用桂枝汤，是不是，但是呢那个脉可是浮，脉沉迟者不行，需要桂枝汤原方加味，加芍药生姜，照原量再加 1 两，另外加 3 两人参。你们看看头前这个 50 条，脉浮紧者法当身疼痛，宜以汗解之，假令尺中迟，迟者不可发汗，何以知然，以营气不足，血少故也。这个脉不足啊，不及的脉，就是营不足。不是这个脉迟，它准就主寒，不是的，它就指血少，血少不充于脉，脉就迟。那么这个发汗之后身疼痛，表未解，可是人太虚了，这个虚你不能够再（发汗），所以我们头前也讲很多了，假设说要有里虚证，也有表证，你非先治里虚不可。那么这个里虚不太厉害，只是脉沉迟，没有其他的证候。脉沉迟说明由于发汗之后，丧失人的体液，夺汗就亡血呀，血液也少，这个时候你再用桂枝汤原方不行了，所以这得知道变化，那么这怎么办呢？

我们讲桂枝汤，桂枝汤这个方剂呀就是安中养液，就是鼓舞胃气，那四味药都与胃有好处，但是脉沉迟呀原方是不行的，只是用那几味药鼓舞胃气不够了，用人参大力而来健胃不可，所以他用人参，加上3两这个分量很重了。另外呢把这个生姜，生姜也是健胃药，生姜和人参一起对于健胃当然更起作用了。芍药是育阴，桂枝汤搁芍药也是这样的，芍药是苦平微寒的药，它是养阴，那么这个血少就是阴不足啊，后世这个说法了。所以这个脉沉迟就是津液缺少，也就是第50条说的营气不足，血少故也，所以脉迟。这样子你再用原方就不行了，所以古人这个用药讲丝丝入扣，你要不恰好，就好不了病。用桂枝汤还是不要紧的，如果你要用麻黄汤就了不得了，你再大发其汗，他本来血液就少了，你再大出汗，这个人非抽不可，那更不行了，就是对，用桂枝汤也不行，你还得想办法健胃，这个胃，我们这个地方，大家要注意，我们寻常说这个津液虚、血液虚，都要壮水嘛，滋阴、养液，都用这个法子。这个在临床上咱们得看，他这个，仲景这个书不是这样的，他有时候用四逆汤，也养液，你得看什么情形，也得辨证啊，后世见到热就是阴虚，生地、麦冬就往上上，那么见到这个见到寒呢就阳虚，就附子、肉桂，这是错的。他这个书啊，真正的津液虚、血液虚，看看什么情形之下，在虚寒，这个阴寒证最虚得厉害了，这个时候津液虚，那个生地、麦冬一点也不能动啊，动就能死人的，你非得恢复，咱们现在说就是理脾胃了，就是健胃，总而言之就是健胃。这个胃气一恢复，自能够化水谷而布津液，自然地就好了。

这个在后世的医书里呀，这一点不谈，一看到阴虚就想办法滋阴，那就错了。他这个书就是这样，这所以搁个脉沉迟，脉沉迟虽然说是营气不足，血少，在他的书上这么说的，但是也是虚寒，里边多少是虚寒，要不这不足之脉怎么现迟呢，这样我们就不能够用解热滋阴的药，那个根本就是不对的，所以他用这个，发汗后身疼痛，表不解，依法应该用桂枝汤啊，但是这个脉沉迟，由于发汗，里头津虚血少而

有些虚寒的反应了，所以他要加，不但加人参，而且还要加生姜，生姜这味药是温中，是一个温性药啊。所以这个方子，他叫个新加汤，就是这个意思，还得用桂枝汤，需新加这几种药味，健胃以滋津液，意思是这个意思。那么这个方剂就是桂枝汤原方，桂枝、芍药、甘草、大枣、生姜，在原方里头加一味人参，另外呢把芍药、生姜都增量，我们看这个方子就治桂枝汤的原方证而胃更比较虚，加生姜，里头也有恶心，张仲景这个书大家都知道的问题一般都不提，其实这应该有呕，应该有恶心，这里的人参也不是万能的药，它就是健胃，健胃也有证候，这个书后面大概有，理中汤我记得就有，什么时候呢？就心下痞硬。《外台》说得明白，这是人参的一个主要的证候，它治胃虚，胃虚到什么程度上呢？我们讲泻心汤的时候就有了，胃虚呀，这个邪气，客热邪气，都往胃这块来，客气动膈嘛，膈就指着心下胃这块了，这样子胃就硬了，无论是水饮或者是邪热之气，都跑到胃这了，这就合乎《内经》上说的话，“邪之所凑，其气必虚”，哪块虚，邪就往哪块去，你用下或者发汗，虚其胃了，那么这个邪气就往胃这块跑，于是胃痞，痞就是这块儿感觉上下不通，而且拿手按着也硬，所以心下痞硬不可下，下之则死，这阳明篇就有了。那么我们用人参呢要注意这一点，人参不是万能的，当然人参和附子啊都能够促进机能沉衰（的恢复），拿现在话说就是代谢机能沉衰了，但是用处各有不同的，真正现虚寒的这种证候，你非用干姜、附子不可。人参这味药是苦、甘，偏微寒，所以在阴证里可以用，在阳证里也可以用。真正虚寒，寒得厉害，真正纯阴证，人参不能用，你看复脉汤、通脉四逆汤、四逆汤都不用人参。用它的时候，有一个特殊的证候，就是心下痞硬，这个病人呐，他说心下痞，按着这块挺硬，食欲不振，有一种胃虚的反应，这时候就要用人参。要是没有这个证候呢，用着是有害无益，用什么药都这样。

李冠杰：这里又出了一个小问题，《康平本》没有方剂，《宋本》

在这一条的后面加了方剂。后来在整理《康平本》的时候有的同学就会觉得《宋本》在这个地方它有方剂，是一个完整的方剂，为什么要缺失了它呢？就把它给补上了。其实补上本身呢没有什么太大的问题，可这里面有一个事儿啊，假设你一旦把这个方剂补上，又不作任何说明的话，这就等于我们少了一部分古代的信息。大家看看它为什么没有方剂？说得稍远一点，这个方剂恐怕是张仲景自己独创的。另外从古人那种简文的习惯看，这个方剂完全没有必要再去写上呀，因为它是在桂枝汤的基础上加了两味药的量又加了一味药，在方剂的名称当中，连剂量带药味全都有了，所以说他完全没有必要费一些笔墨再去写这个方剂。到了王叔和时期，王叔和拿来一看，这个方剂都已经写明白了，为什么不把它写出来？随着人们对文字交流的增多、经验的积累，又发现有一些东西它容易造成人的误会，或者说用着不方便，这本身也是一种进步。加上这个方剂以后，作为使用者学习者来说是方便了，但是却少了另一个信息，古人当初写这个的时候有这样的习惯，他给你提供的信息足以让你明白了，多一个字儿也不写。当然现在我们没必要去评论他好和坏，但这是事实，是我们应该知道的史实。

这个条文在《康平本》里边是降一字格排版的条文。

下边我们解读一下：

“发汗后”，这个条文特别简，我们要把这个条文看成一个整体来解读。整体解读从这个“发汗后”出现的症状，也就是说出现的变证和这个治疗的方剂，我们可以理解这个“发汗”一般地说还是指的是正治，基本上是表证用了发汗药。但是这里面如果细品味的话，不排除有表虚证误用了麻黄汤的可能性，这种可能性完全是有的；还有另外一个因素，之所以出现后面的变证，比如这个人平素体质就非常虚弱，如果发汗不当也会出现这种情况。我们把它简单地理解成是表证发汗的话，那么发汗后不但表没愈，反而出现了一些变证，原因是

什么？就是因为发汗不当。这个发汗不当，主要指的是发汗太过，或者说是护理不当，或者说这个人本身就有一点表实的倾向，比如表实证和表虚证错杂，像麻黄桂枝各半汤的那种，如果你单纯地喝麻黄汤，也有可能出现这种症状。

结果出现“身疼痛”，后面还有个“脉沉迟”。既然是整体解读明了了“发汗后”的这个“发汗”，本身是指的一种什么样的发汗，那么他发汗不当以后，这个“身疼痛”就应该是在这个基础上。至少有两个方面的原因，一个是因为出汗太多造成津液损失严重，再加上有一点点里虚，像出汗多了以后也会虚到里啊，津液的来源也随之不足。本来的津液损失的多就需要得多，再加上来源的不足，这就会造成体表组织失养，营养不足出现疼痛。第二就是发汗不当，而造成表证不除。这个在桂枝汤的方后注解里边写得是明明白白，“不可令如水流漓，病必不除”嘛，这儿就有那方面的因素。他还有表证的存在，因为发汗不当，表证也没有完全好，这儿呢就是指的这一类的情况。

“脉沉迟”，在这个地方跟大家提个醒，读《伤寒论》，也就是说读经方的书，你什么东西都不要去死读书。你看这个地方他用了一个“脉沉迟”，一个是它在这个方剂里面，比较有代表性，这是其一；再一个，这个“脉沉迟”它能够代表此时的人体的病理状态。但是临床当中这却不是一个唯一的脉象，并不是说你看到他有身疼痛还有表证，然后你再一摸脉发现脉不是沉迟的，还是浮脉，那么你要再接着发汗，恐怕就要出现比较大的问题了。他这也不是个唯一的，应该灵活地看。

我们一直在强调这个事儿，在经方理论里面，他给你说的脉象也好症状也好，都有他的用意的。因为他那个时候不像我们今天什么东西都可以写得明明白白的，因为他的书写条件受限制，那么他就会有选择地给你写出来。比如在别的地方写到了的，这儿就不写了，或者他写一些尽管是不太常见的症状。在一个方证里边，首先要选这个方

证必见的症，比如小柴胡汤证，那四大主症他要写到前边，这是必见症，但是他有时候还会选择一些有特征的症，不一定是必见，或者说病人主诉往往不会是这个症状，因为它有特征，在其他方证里出现得少。另外一种情况就是它有代表性，它能帮助我们理解这种病理状态。这地方的这个脉象就明显是这样。但实际在临床中，脉象往往要复杂得多，不能用一个单纯的脉和一个单纯的症状去确定疾病的性质。如果具体到他列举的这个脉呢，这个沉脉在这个方证当中他候的是津液虚，里虚，这个迟脉呢在这个方证当中是候里虚而且机能偏于低下，但是还没有达到陷于阴证的程度，到不了那种里虚寒的程度。平时我们都知道迟脉就是候里虚寒，但是这个地方它候里虚，没有明显的寒象。所以说这个脉象，不仅仅是这一条，其他的也都有这一类的，有它的规律性，我们不能机械地去理解脉象。

这儿有一个问题我们应该解释通的，在这个方证当中这个沉迟脉，既然没有那么严重的寒象，为什么会出现迟脉，又沉又迟的那么一种脉？我想应该是这个发汗太过往往是个短时间的事，就说半个小时足够了。汗出得太多以后，在比较短的这一段时间里面，这个人体呀就很快地陷入一种津液虚，机能又低下这么一种状态，这个时候他就有可能表现出这样的脉象出来。但是他跟真正的阴证的里虚寒证还是有区别的，这里没有用附子嘛。如果说有那种情况的话，就应该用附子。

还有一个问题，这一条开头就是发汗后，但是实际在临床中并不一定出现在发汗后。比较典型的像产妇，产妇有什么特点，生产过程当中，人体能消耗非常大，然后她就会陷于一种也是一种短时间的（虚弱证），坐月子嘛，也是时间相对地说比较短，跟体质不一样。她出现一种虚弱的情况，再加上她经常出虚汗，容易陷入一种津液比较虚的情况，在这种情况下她患了感冒的话，就容易出现这个方证。

这儿说的都是一些典型的有代表性的症状，其实在临床当中像本

方证还会有一系列的表虚证的症状。比如汗出、会有点恶寒啊，这都有可能存在的，甚至发热也有可能的。因为有方剂在后边，古人就把它给省略掉了。但是我们今天读，你应该想到这类问题。

这一条所论述的病理是一个阳性病，这一点挺重要。这个不要把它认为是一个阴性证，这不是阴性证。可以说它比较接近阴性证，但是毕竟还不是，要是的话桂枝加附子汤或许比它要管用。这是一个阳性的表虚证又兼津液虚，还有比较小程度的里虚。

下边做一个小结：太阳病，因发汗太过，不但表证未得痊愈，反而出现了身疼痛，脉沉迟的症状反应，此为桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主治之证。

下面看这个方剂，在桂枝汤的基础上芍药生姜各加了一两，另外又加了三两人参。人参在这个方剂当中的主要的作用，它就是健胃补虚，补中虚生津液。它可以促进胃肠对水分的吸收，改善人体的机能。另外加了一两生姜，也可以说它在协助人参增强这些功能上能起到一定的作用，同时生姜还有走表的一个功能，它可以强化体表功能的恢复。增加芍药，我们对芍药的这个药理早就讨论过，实际上它就是用来改善人体肌肉组织的，与拘挛痛有关的那些营养成分的这么一个作用。

临床统计资料当中这个方剂的方证都是表现出一些什么样的症状？这个方证里边表现最多的是身痛。身痛有 25 例，神疲乏力的 16 例，大家可以比较一下哪一类的症状会出现的几率比较高：汗出是 11 例，畏寒 11 例，头晕 10 例，食欲不振 7 例，发热 6 例，脘痞 5 例，面色无华 4 例，这肯定就是人的体质比较弱了。这当中像身疼痛这一个症状在临床当中描述的五花八门，有的说他身疼痛，有的说是腰酸肢痛，还有说腰痛，还有说肢体酸痛，也就是说病人主诉可能会是各式各样的。实际上主诉本身也就说明了病人自己的主观感觉，比如腰酸肢痛这类的，这个基本上还涉及到全身大部分部位，像腰疼，

他说的就是一个腰疼，肯定他的腰的部位疼得程度要比其他部位要严重，或者说比较集中。

舌质：淡舌 7 例，淡红舌 1 例，是淡胖舌有齿痕 1 例，红舌 1 例。

舌苔：白苔 6 例，薄苔 4 例，白而少津 2 例，无苔 1 例。

脉象：刚才我们一直在说脉象，现在咱们就看看这个脉象，细脉 10 例，沉脉是 9 例，无力的脉是 8 例，迟脉 7 例，缓脉 4 例，弱脉是 3 例，浮脉 2 例，弦脉 2 例，微脉 2 例。总地说沉迟脉还是比较有代表性的，像弱脉，微脉，都跟沉脉相对地比较接近。

对于现代疾病治愈的记录：末梢神经炎、面神经麻痹、肌肉疼痛、关节疼痛、慢性胃炎、胃溃疡、神经性头痛、美尼尔氏综合征、男女更年期综合症、习惯性感冒、上呼吸道感染反复发作、妊娠恶阻、产后高热、麻疹。治疗面挺广泛。

发汗后、喘家不可更行桂枝汤、汗出而喘、无大热者、可与麻黄杏仁甘草石膏汤、（63）

麻黄四两去节 杏仁五十个去皮 甘草二两炙 石膏半斤碎锦裹

右四味、以水七升、煮麻黄减二升、去上沫、内诸药、煮取二升、去滓、温服一升、

胡希恕：这个针对桂枝加厚朴杏仁汤说的，这个发汗后，一般表不解是用桂枝汤，唯独这一条你不要用，“汗出而喘”，汗出，桂枝汤不是治汗出嘛，太阳中风，发热汗出，恶风，脉缓者用桂枝汤了，那么这个喘呢？我们头前也讲了，喘是气上冲的一种反应，如果有气上冲的反应当然可以用桂枝汤了，唯独这个不行的，这个什么道理呢，

咱们好好把它解释一下。

这个怕你想到桂枝加厚朴杏仁汤，那么桂枝汤解表，加厚朴杏仁兼以定喘，这不跟这个意思一样嘛。其实他这个意思不是，他这个汗出啊，那不像桂枝汤那个汗出啊，这个汗出是这个汗多得很，而且这个汗相当地稠、粘，这纯粹是热，这个喘也是热壅，这个表不解，表邪也盛，这个热往上壅得厉害，他这个汗出有阳明病的味道，但是又不到承气汤那种情况，我们讲阳明篇就有了，阳明病法多汗，里头热嘛，是蒸汗外出。这个一方面表未解，一方面里头也有热，所以这个汗出得相当地甚，而且这个汗臭味也重，咱们闻着汗臭味也重得很，也比较稠、粘。这个喘最厉害，麻杏石甘这个喘顶厉害的，一方面有表证，有麻黄证，一方面热往上壅，就是石膏证了，所以假设这个汗出而喘。

“无大热者”，无大热我们上头也讲了，既没有表的渐渐那种热，也没有真正到阳明病那种情形蒸蒸发热，那非用承气汤不可了，不到那种程度，但是确实也是里热。“可与麻黄杏仁甘草石膏汤”，那么这样子呀因为邪盛加重麻黄，同时有热，这就是麻黄汤的一个变方，麻黄汤把桂枝去了，这个里热呀桂枝不能用，然后加石膏以解其里热，是这么一个方剂，就是根据麻黄汤一种去加法了，去桂枝加石膏，这个方子咱们也常用，尤其肺炎都爱用这个方子，其实这个方子也不是肺炎特效方子。真正的汗出而喘可以用，但是只能够用一次，你不能连续用，假设这个药吃了，病好一些，但是热没完全去，这时不要一直搁麻黄，变其他解热清肺的药还是好的。这个方子是最常用了，我们一般治这个哮喘也有时候用，真正是汗出而喘，确实里有热。他这个方剂后头，本云，后头，黄耳杯，这个大概是错的。他凡是本云啊，都说明这个方子原方，大概本云麻黄汤，今去桂枝加石膏，大概是这么一种话。他弄个黄耳杯，这个黄耳杯，有注家说它是个器皿。要是个器皿，这个本云黄耳杯就没有意义了，大概是本云麻黄汤，今去桂

枝加石膏。他搁个黄耳杯。这个书的错误是有的，你象这个就是明明白白的。

李冠杰：这个条文里边，在“发汗后”后边有“喘家”两个字，《宋本》里边没有这两个字。这两个版本有这么两个字的区别。

这个条文在《康平本》是降一字格排版的条文。

下边解读一下：

“发汗后”，是造成这个方证的原因之一。当然这也不是唯一的原因了，在这个条文里边把它当作一个重要的原因来论述。实际上不发汗后，也会有这个方证的情况。咱们不能那么机械地解读。

“喘家”，在学习桂枝加厚朴杏子汤的时候，已经都学习过了，就是素有喘疾的人。那么这种人有什么特点呢？他的呼吸系统就较常人微弱，当人体内环境发生比较大的变化的时候，常常要从这个最薄弱的环节发作出来。

“不可更行桂枝汤”，在这个条文里边，这一句话不能轻易放过，这一句话有着特殊的意义。这个“更”字，在这儿应该是“再”字，“不可再服桂枝汤”。他为什么要这么来表达呢？就是经方里面有个治疗原则：凡是表证，发汗以后表不解，或者经过泻下以后表不解，只要还是表现为表证，就要用桂枝汤来治疗。但是，这个治疗原则还有例外的情况，发汗以后，或者泻下以后（顺便把第 162 条也讲了），不能再行桂枝汤治了。那么为什么呢？这儿我们看看方剂，就很明白了。因为经过了误治以后，他产生了里热。人体一旦有了里热，这是桂枝汤的禁忌症，桂枝汤就不能用了。所以“不可更行桂枝汤”。如果考虑到“喘家”这个因素的话，再来看看“不可更行桂枝汤”，有明确的指向，指的就是桂枝加厚朴杏子汤。这个时候尽管他喘，也不能用桂枝加厚朴杏子汤了，因为有里热。

“汗出而喘无大热者”，是这个方证的典型的症状反应。这个汗出，不再是表虚证了，主要是由里热造成的。“汗出”，尽管在文字

上我们看不出，但实际在临床当中，由里热而产生的汗，携带着大量的因为内部器官偏于亢奋而产生的代谢物，闻起来味道比较重，摸起来手感比较粘；桂枝汤证出的汗，要比这个汗清爽一些。

另外呢，这个方证在临床当中还会存在着一系列的里热的证候。比如舌苔可能会有点黄，舌质有点红，脉象偏于数。脉偏于数，桂枝汤证如果发热的话，也会偏于数脉，浮缓脉。但是麻杏石甘汤的脉有时候会近乎于洪大。再一个仔细问诊的话，患者自己的感觉也会明显区别于桂枝汤类方剂的那种方证。在这个方证的统计里边，有一个症状叫鼻煽，麻杏石甘汤证中有时候会出现这么一种情况。因为有里热，特别是里热严重的话，患者呼出的气，自己感觉到有灼热感，鼻子都觉得往外呼气的时候觉得很热，这就是因为里热太盛了。

再一个就是“喘”，喘本身有多方面的因素：一个是本来病人可能就有喘的毛病，再加上新得了病以后呢，喘加重了；第二呢，是有表证，体表的呼吸功能不够健全而造成喘；第三呢，里热也经常会造成人的喘。实际上，单纯的里热造成喘的话，是因为机能过于亢奋，再加上呼吸系统又比较薄弱，承受不了过热的内环境，造成咳喘。

这个“无大热”，应该客观地来理解。一个呢，无大热，能够说明这个方证的一个病理特点。我们现在理解呢，一般情况下不会出现过高的体温，这样理解就比较准确一些。不至于像大青龙汤证的高烧，只能这么说。

病理基础呢，因为有汗出，相当一部分热量都带出来了，不至于造成很高的体温。

所以，麻杏石甘汤是一个解表清热的一个方剂。

那么这儿就有一个问题了，麻杏石甘汤证的表证，是表实证还是表虚证？因为有汗出。我们从药物组成上就能够理解，严格地说还是一个表实证。但是这个表实证跟大青龙汤证的表实证相比的话，有着程度上的区别，没有实到里热很盛不得汗出的那种程度。

这一条所论述的病理，就是表实证同时伴有里热。但是我们应该时刻记着一个事啊，实际临床当中麻杏石甘汤证也有无汗的情况，同时也可能会见到高热的。这个临床当中都有的，要仔细辨证。

下面看看方剂，一共四味药组成。实际就是麻黄汤去掉桂枝加上石膏。也可以理解成麻黄汤的一个加减方。因为此时的人体，里热比较严重，再用桂枝不合适，所以就把桂枝去掉了，加上了清里热的石膏。可见这个时候，里热是矛盾的主要面。石膏在这个方剂当中的作用，就是清里热。

下边呢，再看看这个方证。麻杏石甘汤证，总共统计了 367 例，这是一个常用的方剂。那么在季节发病上有什么特点？春季发病的 66 例，夏季发病的 39 例，秋季发病的 29 例，冬季发病的 76 例。我们为什么把季节发病的规律放在这个地方？发病率最高的是冬季和春季，最低的是秋季，而且冬季和夏季差了将近一倍，冬季是 76 例，夏季是 39 例。这是一个什么样的方剂？外有表证，里有里热。

很多其他中医的书，解释人体和环境的规律的时候，把它机械化了，甚至提出冬季不可用石膏。什么冬季不能用凉药，夏季要慎重用热药。治病的规律在哪？在于得病以后的疾病反应。在于准确的辨证。不管什么季节，他得的是什么病，你就给他用什么方剂来治。咱们从这个统计资料上就能看得非常清楚。

我们学中医就好像在淘金，淘金一开始淘到手里面的是泥沙、石、金子混在一起了，你得学会了把那些杂质淘出去，最后剩在你手里的才是金子。你要把金子淘出去，最终你得到的就是一把泥土、一把沙石，毫无价值。中医里边虚假错骗很多，需要我们仔细去淘。

麻杏石甘汤的临床统计症状：咳喘 303 例、发热 231 例、大便干燥 107 例、口干渴 95 例、尿赤 75 例、烦躁 68 例、鼻塞 16 例、呼吸短促 60 例、咽部肿痛 40 例、麻疹 29 例、痰黄粘稠 50 例、汗出 17 例、无汗 14 例，这是有记录的。无汗和有汗对比太接近，特征性不

那么明显。

舌质：红舌 120 例、淡舌 3 例、干舌有芒刺、瘀点各 1 例。

舌苔：黄苔 33 例、黄腻苔 32 例、薄黄苔 26 例、薄白苔 25 例、白腻苔 7 例、白苔 5 例。

脉象：浮数脉 48 例、滑数脉 40 例、数脉 21 例、浮滑数 13 例、弦数 10 例。大家看啊，数脉在这个方证里边差不多是必见的。

有应用这个方剂机会的现代病：感冒，流感（包括甲流，这一点很重要，这个甲流肯定有里热在），肺炎，急性支气管炎，慢性支气管炎急性发作，大叶性肺炎，支气管肺炎哮喘，麻疹肺炎，嗜酸细胞增多性肺炎，膀胱炎，尿道炎，急性结膜炎，急性虹膜睫状体炎，慢性鼻炎，百日咳，哮喘，过敏性哮喘，风疹，流行性腮腺炎，脑炎，麻疹，荨麻疹，小儿遗尿，小儿尿频，夏季热，小儿痉挛性喉炎，口疮，肺心病，慢性结肠炎，喉头水肿，酒糟鼻，玫瑰糠疹，皮肤瘙痒症，接触性皮炎，痔疮，痔疮水肿，内痔脱垂嵌顿，疖病。还有伤寒、副伤寒。

如果一个麻杏石甘汤证，既没有汗出，同时又有高热，那么它跟大青龙汤证如何区分呢？

这个方证跟大青龙汤证，特别是在无汗高热的情况下非常接近。我们比较一下，跟大青龙汤证作一个鉴别。大家看看大青龙汤的方子，大青龙汤就包括了在这个方剂所有的药物。我们把大青龙汤多出来的药物看一下就会从中得到启示。大青龙汤比麻杏石甘汤多了桂枝二两，生姜三两，大枣十枚；另外呢麻黄比这个方剂多二两；杏仁比这个方剂少了十枚。还有石膏的量，这个方子是半斤，大青龙汤是如鸡子大。

这儿啊，咱们先说一个问题，石膏同样的一本书上为什么一个是用斤来计算，一个是用如鸡子大？实际这个问题非常简单，就是这两个方剂不是一家的方剂，它的来源不同。来源不同，所以计量法不一样。今天实际测一下啊，实际上最后的结论，这两个非常相似，非常

接近，基本上就是半斤左右。这就更能证明这两个方剂是来自两个不同的渠道。再去看看桂枝、生姜、大枣，这不是近似一个桂枝汤吗？

大青龙汤证所表现出来的这个症状，一般都要比麻杏石甘汤重。头疼、身疼痛、烦躁；另外，大青龙汤证有体表停饮的情况。麻杏石甘汤绝对没有这个问题。这是很大的区别。

还有，这个方剂跟桂枝加厚朴杏子汤。“不可更行桂枝汤”，就说千万不要再给桂枝加厚朴杏子汤。不要搞混了，不要辨证错了。这两个方剂比较一下的话，从字面上看，症状非常明显，都是有热，热也不是很高，同时又有汗出，又有咳喘这一类的。但是它们最根本的鉴别点，就在于有无里热。有里热了，那就是麻杏石甘汤证；没有里热就有可能是桂枝加厚朴杏子汤证。

这个方剂在临床应用当中，有一个非常重要的特点，就是这个方剂不能连着用。这一点我自己是深有体会。好几年前了，也就这个季节，天特别热，我自己感冒了。感冒了以后咳嗽，我就发现啊，小陷胸汤也是对这些热证，而且治咳嗽挺好。我当时感觉对我威胁最大的就是咳嗽，咳嗽就是一个比较主要的证。我想先喝点小陷胸汤，看看会是什么感觉，我就喝了。喝了以后，20分钟就不咳嗽了，真的不咳嗽了啊。但是不咳嗽了，还不如以前咳嗽舒服呢，更难受。因为不是那个方证，更难受，它解不了表啊。后来我一看，这个肯定不行，只能是体验一下。然后又喝麻杏石甘汤，喝了以后很快就很舒服了。我感觉这个药喝了这么舒服，好得这么快，我接着喝吧。第二天又接着喝，后来就越喝越觉着不舒服，觉得虚了，老在出汗。所以这个方剂啊，胡老也说了，只能用一次。

但是我的感觉啊，连着用两次，就说服两剂，如果说症状非常明显的问题不大，但是往下不要再喝了，这个方剂不能喝了。如果病好不了怎么办呢？这也是我自己的体会。把麻黄减量，减到只有原来剂量的三分之一，让他喝，肯定是既不至于虚人，又能清里热，这是一

个办法。但是这样呢，恐怕也不能喝时间长了，因为大量的石膏会有点伤胃。

还有一个问题就是，我也在临床当中碰到过，往往这个人喝了这个方剂之后，因为这个方剂见效很快，明显得轻了，但是还好得不是很利索，这个时候他会出现某些小柴胡汤证。这时候你合上小柴胡汤。当然要是有大柴胡汤证，要合上大柴胡汤也没问题。合上柴胡剂疗效也非常好。还可以多喝几天，这个病就好了。

我楼上有个会计，他感冒了，他就是一个麻杏石甘汤证。输了三天的液以后，他出现了柴胡证。我就给他小柴胡汤合上麻杏石甘汤各半。就服了两次就好了。总地说还是要辨证。

另外还有一个问题啊，就是《宋本》的方后注解的最后，有一个“本云黄耳杯”。我跟大家说，在比较权威的教材里边，对“黄耳杯”作了一种解释，是一种古代的器皿，椭圆形的，有两个耳朵状的手柄，是黄铜做的，所以叫做“黄耳杯”。而且它的容量，就是一升。这样说呢，非常合情合理。这个方后注本来后边说的是一次服一黄耳杯，后来觉得剂量上不统一，就改成一升了。

发汗过多、其人叉手自冒心、心下悸、欲得按者、桂枝甘草汤主之、（64）

桂枝四两去皮 甘草二两炙

右二味以水三升、煮取一升、去滓顿服、

胡希恕：那么前边两个全是发汗药物，这不一定是误治你可知道，那么发汗后，这个病重，他当时不解，有的可以用桂枝汤。那么看他有些虚象，就是这个津虚血少啊，脉沉迟啊，可以用新加汤。那么也有病人内热素盛，虽然表证发过汗了，但是反汗出而热壅，这个麻杏

石甘汤证了现这个证，这个也有。这都是不一定是治错，这种情形也可以发的。

那么底下这个呢，就是发汗不得法了，这是错误的，发汗过多，所以咱们讲桂枝汤，都要是取微似汗，就咱们用麻黄汤也是一样，不要大捂大盖，你把人弄得大汗流离，这个病不会好的，而且这个伤人体液太甚。这一段就说明这个发汗，不得法，而使之汗太多，也有毛病，这个就是单说这的，这就由于发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。叉手自冒心就是交叉其手按着心下这个部位。

那么发汗太多啊有两个问题，一个问题，你多汗者血就少，血不足以养心，心就跳，这是第一。第二呢，我们出汗都是上体部特别多啊，尤其咱们吃药啊，这个发汗，上体部这个水分呐骤然间丧失太多了，这个上下体的体液失调，下边的往上来，这是准的，这个就是骤然间发生的高度的气上冲。那么他这个叉手自冒心啊，一个是心悸，一个是这个气冲得厉害，所以按着才舒服点儿。那么这个呢，当然就用桂枝甘草汤就可以，这个桂枝这个药啊，它主要就是治气上冲，同时也起治心悸的作用，可是得大量用，这个我们在治心脏病啊，有的时候用在这个心悸，你要用个三钱二钱一点不顶事，你看看这个方子用多少，你看看，这个桂枝他用了四两，甘草用二两，它是顿服啊，顿服这个量大着了，这个桂枝就顶一两二，拿到现在度量上，这个甘草是六钱了，这个桂枝我一两是用过，就是这种心脏病啊，特数的这个特殊心悸，烦悸，那么这个时候桂枝可以多用，所以桂枝这个药，最平和不过，咱们现在把它形容得，简直是了不起的一个大热药，简直动不得，不是这个事，你看这个就看出来了。这只是一个发汗过多，造成这个心悸，加上心下这气往上冲，他叉手自冒心，欲得按者，那么这个时候呢赶紧降冲气，治心悸。这个桂枝加茯苓啊，治心悸更好，我们对这个心脏病常用的法子。你看这甘草大量用，也是搁六钱，它

就是急迫，这种心跳非常的急迫，治急迫他都用甘缓的法子，都用这个，一般都用甘草。他不是那样的，该多用他真多用。这个主要是气冲心悸，特别厉害，用这个单方桂枝甘草，它也解表。他这个发汗过多，这个表还是不解你看，那桂枝汤你们看看方后语就有，说如果大汗流离啊，病必不除，他表还不解。那么这个方子呢倒不能发汗了，没有（生）姜在里面佐之，光一个桂枝，并不出什么汗，尤其大量搁甘草。但是它治身疼痛，这桂枝甘草（汤）也治身疼痛。后来，你象这个理中加上桂枝甘草也治身疼痛而协热下利，后头也有。这就是桂枝汤的最简化方，但是一般用呢都不用这么大量，这是气冲心悸特别厉害，可以用这么大的量。你们遇到这个心悸，你们试验试验，这个桂枝用到六七钱，一点问题没有，你不重用，它不起作用。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降两字格排版的条文。

那么解读一下：

“发汗过多”字面的意思非常得清晰，但它是造成这个方剂的病因之一。根据经方的理论来分析这也不是唯一的原因，实际临床当中碰到的这个方证，因为发汗过多造成的非常少。

“其人叉手自冒心”是这种病的患者临床中常见的一种下意识的动作，他就觉得这样好一些。叉手就是两个手交叉着，“冒”字在这个地方应该当做覆、盖的意思，就说两个手交叉着覆盖在胸口这个地方。它用来形容病人因为心悸得严重，以至于两个手盖在胸前这个地方。就形容这种样子，还是比较生动。

“心下悸、欲得按”，是这个方证的一个具体的症状和患者的自我感觉。“心下悸”应该是心悸，“下”字是不是原文作者就这么写了不敢说，但是它说的方证应该是以“心悸”为主，“心下悸”不是，那是茯苓甘草汤证的一个典型的症状。“心下”是指的胃口，“悸”是有跳动的情况，桂枝甘草汤出现这种情况非常少，那都是既有气上冲，又有那个部位有停饮的情况。但这个方剂它没有停饮的证候。

这一条所论述的病理是一种表虚证、津液虚、气逆的病理状态。

这一条里的发汗过多，本身就把这个意思说明白了。但是实际临床当中，没有发过汗的，常常也有汗出，有心悸，甚至有的还小便频数。

我这儿有一个比较典型的案例。就是我刚才说的有肺结核的那个人的母亲，80多岁的老太太。她活动不太灵便，心悸，有时出汗，还小便不太好。当时她没有过来，她儿子跟我说的，问的主要就是些症状。我想了想，老太太年龄这么大了，小便也不利，频数，我就给她做了点真武汤。她说吃了真武汤以后，小便解得更多了，心慌的感觉一点也不减轻。我说那不行，得去看看，我就到她家。老太太耳朵有点聋，可能与耳聋有点关系，她说话声高气粗，精神还特别得好。她肯定就不是真武汤证了。我就给她桂枝二十克、甘草十克，这也是原方比例，让她煎了分六次喝，结果没有喝完就好了。这个病还有很典型的一个症状，出汗就呼呼地出一阵子。后来我又碰到这种病人，也有这么一个特点，就是阵发性出汗比较明显，再一个典型的症状就是心悸。古人总结得非常好，都是些典型症状。

咱们再多说一点，在网上有好多同学或者同道遇到不好处理的病人，总觉得我认识某某人，我告诉他，就能帮我解决。我非常理解这种心情。可是这种方式很不好，因为你觉得四诊资料可能很全了，但是有时候却没问到，可能会有遗漏，这是很常见的情况。就如我在青岛的两个学兄学妹，一开始是在电话里跟我说碰到一个什么病人什么情况，我就说给点治疗建议，但时间长了就觉得不是很灵。后来他们就让我过去看看，去了以后我四诊的结果跟他们原来说的相差很大。最后用那个方剂，跟我原来建议的方剂都有着质的区别，有的方向性都有问题。所以说这种方式不太好。像这个老太太虽然离我不是很远，但因为没见到人还出现了这种情况。

作个小结：由于发汗太过，患者出现较为严重的心悸症状，常感

觉摁住心脏部位较为舒适，甚至表现为双手交叉覆盖于胸前。此为桂枝甘草汤主治之证。

这个方剂一共就两味药，非常简单，桂枝四两，炙甘草二两。桂枝在方剂中肯定是个主药，它的主要作用其实也非常简单，就是降气冲、解表。甘草的作用是缓急、补中、补津液。

这个方子如果跟别的方子放到一块儿，体悟得会更深一些。比如苓桂术甘汤、苓桂枣甘汤、茯苓甘草汤，这三个方子的病理跟桂枝甘草汤非常接近，但是又有质的不同。这三个方子都包括了桂枝甘草汤，同时这三个方子又有停饮的因素，都有水证。之所以这三个方子不同，在于它们停饮的部位导致的症状反应不一样。但是桂枝甘草汤在里边的作用却是恒定的，都是用来治疗气上冲的。这样来想一想，桂枝甘草汤就很容易理解了。再回过头去想那几个方子，仔细去品味品味，它们都有气上冲的问题。还有一个桂枝加桂汤，跟这个方剂也可以联系起来，这个方剂和桂枝加桂汤的区别，在于这个方证集中于心胸部，但桂枝加桂汤方证它是从腹部到胸部都涉及到了。桂枝加桂汤跟桂枝甘草汤从药物上分析，桂枝加桂汤偏于里虚一些。

这个方剂在临床中应用还时常会出现用错了的时候，因为它的典型方证“心悸”在很多方证当中都有可能出现。我的体悟，在临床当中最好的办法就是用排除法。我们再举几个方证就知道了，比如说心悸有明显的水证而且陷于阴证的，就是真武汤证；如果心悸有明显的里虚寒的，又陷于阴证的就像四逆汤证；心悸有半表半里证的，偏于里实证的，像四逆散证；比如心悸又有因为虚热证，像炙甘草汤证，还有因为血证的，像大柴胡汤合桂枝茯苓丸，这就比较典型的了。心脏病也会感觉心悸。但是有明显的柴胡证、瘀血证，还有因为情志方面的比如桂枝甘草加龙骨牡蛎，就很明显了，这本身就是既有情志方面的又有气上冲，那么就用了这个方剂，又加上了龙骨牡蛎。还有因为纯属于里热造成的心悸，比如白虎汤证也有可能会出现心悸。

我刚才说的那个老太太，在给她的辨证过程当中，实际后来就用了白术，一看就知道不是一个阴证，精神特好，非常精神的样子，她不会是个阴证。不会是阴证的话，像好多里虚寒证什么的都排除了。再加上吃了真武汤小便毫无作用，那么水证的可能性不大，尽管她小便有点频数，结果喝了这个方剂管用了，排除了没有那些方证的特点。

下边我们看看临床统计，统计的案例一共是 22 例。症状中心悸的只有 16 例，汗出的有 10 例，胸闷的 9 例，头晕的 8 例，坐卧不安的 8 例，叉手自冒心的 7 例，面色苍白的 5 例，四肢不温的 5 例。其中呢汗出这个症状，有的病人自述说大汗淋漓，有的是汗出较多，有的是一般的汗出，有的是自汗，也是各种表现都有。总地说它是一个表虚证。

舌象：淡舌 8 例，淡暗有瘀斑 1 例，光润舌 1 例，舌胀 1 例，淡暗舌 1 例。有舌象记录的一共 12 例。

舌苔：有 11 例的记录，淡薄白苔 6 例，无苔的 2 例，白滑的 2 例，腻微灰的 1 例。

脉象：有脉象记录的是 17 例。虚脉 12 例，沉脉 5 例，浮脉 3 例，濡脉 2 例，结脉 2 例，细脉 2 例，数脉 1 例，代脉 1 例，涩脉 1 例，紧脉 1 例。这里边有一些脉象，比如说代脉，恐怕有加减的情况。这个方剂在临床，特别是后世应用当中，原方用得不多。所以说看起来好像包括了这么多的脉象，恐怕有其它的证掺杂着，往往都有这方面的因素啊。它还有一个用药规律、加减规律，如果都吸纳进来，整个学习过程就很长了，很麻烦了。咱们现在就拣主要的跟大家说。

治疗的现代疾病：低血糖，窦性心动过缓，冠心病，心脏性哮喘，先天性心脏病并发肺炎，瘰病，急性前侧壁心肌梗塞，心率不齐，心肌缺血，心动过缓，肺心病，风心病，慢性胃炎，慢性胃溃疡。

这个方剂的应用有一个很重要的问题，就是临床当中要应用这个方剂，药量应该适当的加大。比如用桂枝汤，用桂枝汤现在用桂枝 9

克，芍药 9 克，其它的就以此类推了。如果用这个方剂，桂枝和甘草的量都应该加大，它的道理在哪儿呢？这是古人从临床当中得出的实际经验，这个原方的桂枝用了四两，与桂枝汤相比就多了一两，但是这个方剂要求顿服，顿服就是一次服药量，四两是一次的服用量。我们再折算一下的话，这个药量就大了。按照现代的计算四两就是 60 克，如果按着《伤寒论》上的原量桂枝汤一剂，桂枝是 45 克左右，分三次服，煮取三升，每次服一升，是三次的服药量。这个 60 克是一次的服药量，那个相当于桂枝汤一剂是 15 克，那么这儿一剂就是 60 克，这就要高出它四倍，所以用药量要大一些。而且这两味药的比例也要按照原方的比例。

有一个问题大家需要注意。我们在学习的过程中你不会只看经方的书，也不会光看胡老的讲座，还会看其它的一些书。看这些书的时候有一些问题就需要特别的注意一下。我在整理这些资料的时候，其中有一个教材性质的、学院里比较权威的资料里，因为麻杏石甘汤是一个常用的方剂，它列举了很多专家应用的临床研究。举一个例子吧，它说“某某专家用麻杏石甘汤来治疗风热感冒，有效率是多少，治愈率是多少，无效的是多少等等，列举了一大堆的数字。有大概是十多例无效。这是经方界，推而广之包括中医界在现代的历史条件下出现了一种新的倾向——用研究现代医学的方式来研究中医、经方。从理论上说，经方只要辨证正确、方证相应，疗效是 100%，不存在无效或者。为什么它会出现多少例没效呢？其实不是它这个没效，反而让人感觉到经方治病也是时效时不效，这就等于给经方扣了一个帽子，是这种研究的课题选题上、方向上本身发生偏差了。经方治的是证，不是病，那个风热感冒不是麻杏石甘汤证，关键问题在这个地方。它如果是大青龙汤证？也可以说它是风热感冒，它也有里热嘛！要如果用麻杏石甘汤去治大青龙汤证，就难以取得好的效果。而且现在风热感冒的面很宽，没效的好多就是因为它不是麻杏石甘汤证。

我们现在如果研究经方不应该是用这种方式。我自己设想的研究方式，总有一天人们会走到这条路上，只有这么一条路。假设有一个经方高手在这儿看病，你可以有意去找一部分病人来让他诊断，诊断完说是什么方证，然后就给相应的方剂，服了以后确实好了。好！你再去比较服药之前的指标和服药好了之后的指标，这里边肯定会有规律的。虽然现在技术手段还非常有限，但这是一个方向，迟早得从这个方向上找到突破口。而不是说用了一个现代的研究方式，就可以改变经方方证相应的基本规律。那怎么可能呢？经方唯一不能改变的东西，你偏偏要研究把它改变了，最终不碰壁才怪呢！而且现在很多人都这么研究经方，日本人研究经方相对来说比较认真了，还出现“小柴胡汤致死人命”的事件呢，其实吃亏也吃在没有去研究方证之间的规律，要去研究方证和人体之间那些古人还没有了解的指标规律，而不是去研究病和方剂之间的规律。其实这个东西稍微换一换角度，就很清晰，任何人都能看出来。但是就是很少有人去那么想。比如说用经方治疗肝炎涉及到 60 个方子，这至少说明肝炎在用经方医学来诊断，它有可能是在 60 多个不同的病理状态下，而在相同的部位发了病。知道这个规律再去研究，你还会去研究什么经方治疗肝炎吗？比如小柴胡汤，都说清胆热、利肝胆，就是说小柴胡汤治疗肝炎，研究单方不行了，就开始加减什么的，比比皆是，到最后是行不通的。但是初学的人发现这个东西吸引力太大了，甚至连研究这个的专家都不能抗拒。为什么呀？如果方剂和疾病之间存在着某种规律，什么方剂就能治什么病，那得多好啊！要真有这样规律在的话，那治病得简单到什么程度啊，比如说肝炎就用小柴胡汤，心脏病就用真武汤，肾炎就用越婢加术汤，要是都这么套上的话，那么人人都成了医学家了嘛！这么简单的道理就没人去做，只能说对抗性的那种理念太深入、太容易被人接受。我们在学习的过程当中，要学会去鉴别，要学会去增强自己的免疫力，不要被别人轻易地误导了，这样可以缩短你学习成功

的路程。

发汗后、其人脐下悸者、欲作奔豚、茯苓桂枝甘草大枣汤主之、（65）

茯苓半升 桂枝四两去皮 甘草二两炙 大枣十五枚擘

右四味、以甘烂水一斗、先煮茯苓、减二升、内诸药、取三升、去滓、温服一升、日三服、

作甘烂水法、取水二斗、置大盆内、以杓扬之、水上珠子五六千颗相逐、取用之、

胡希恕：这个也由于气上冲，同时这个发汗，他里头有停水的话，只是发汗不行，咱们头前，桂枝去芍药加茯苓白术汤那一条你可以参看。那么这一段也就是这个情形，他底下有停水，就是小便不利，膀胱蓄水，这时候非利小便才能解表呢，这时候你发汗就是错的，所以发汗之后，这个病不是不可以发汗的，表病吗，可是马上就出来了其人脐下悸者，脐下就是关元膀胱部位了，那么这个地方跳，这就是水之欲动的一个貌了，一个应证了。欲作奔豚，这就要发作奔豚证了。

这个奔豚是怎么个情形呢？这是《金匮要略》上的一个病名，他说这种病啊，气从少腹上冲胸咽，发作欲死。它这个往上冲啊，那么这个人当时就是受不了，发作起来人反倒要死，可是复还止，它一会儿就下去，下去人就像好人一样，定名一个奔豚病。那么由于这一段后头就给定了名堂了，说这是肾气往上来，其实也不光是肾气，哪光是肾气呢。这个奔豚不一定得有水，那么我们后头就有了，桂枝加桂，那光是气上冲，只是气上冲，那也是奔豚，携带水上冲也是奔豚。这个就由于误发，虚损人的病，误汗，那么这个呢应该利水表自解，就是你这个解表的药里头合用利尿的药，自然表就解了。你要是不知道

这个，就用发汗药，激动里饮那是病变百出，这是一个，那么我们方才讲了，由于发汗导致气上冲，这个气上冲也能诱导着水往上冲，所以心下悸也是个预兆，这就是水伴着气要往上来了，所以他搁个“欲作奔豚”，那么就真正发作奔豚，这个方子也好使的。只是有水，小便不利，所以既用桂枝降其气冲，桂枝甘草，这个也是桂枝甘草这个方剂了，另用茯苓、大枣以利水。大枣这个药也去水呀，你看十枣汤他不搁甘草，搁甘草不行，这个甘药里头唯独大枣利水，一般甘药都不利小便，所以这甘草不行。这个桂枝虽然也用 4 两，甘草也用 2 两，这个方剂可不同于上个方剂，上个方剂是顿服，这个他煮取 3 升，一回服 1 升，这是 3 剂，这个量不大了，这个我们现在用的就是桂枝 4 钱，这个心的悸动不像上边那么厉害。那么这个方子就是桂枝甘草汤证，小便不利，脐下悸，就可以用这个方子。

那么真正奔豚，脐下悸或者腹挛痛，这个方子也好使，这大枣也治肚子疼，也治挛痛。这个方子煎法用甘澜水，什么叫甘澜水呢，他底下有个注解，“作甘澜水法：取水二斗，置大盆内，以杓扬之，水上有珠子五六千颗相逐，取用之。”这是古人的一个看法了，这不是水往上攻嘛，水化气总是用甘澜水好，其实现在这个药谁也不这么做，用不着，就用普通的水煎就行，不是古人的这么一种（方法）。古人的方剂里有一些言语习惯吧，认为甘澜水较比好，它在水的上头，是泡，使水化气呀，这个水好，其实不然的。

这一段讲的是误发了停水、蓄水人的汗，就是膀胱有蓄水，小便不利，你发这样人的汗不行。我们遇到里头有水饮，在上头这类的，你象咱们说这个小青龙汤吧，心下有水气，表不解。那么如果小便不利，他膀胱蓄水呢，那你非搁利水药不可。谈到心下有水气呢，得去心下的水。心下的水呢？当然是用半夏、干姜、细辛这类的温性药，不然的话这个病也好不了。这个地方都很好，帮助临床啊，你象咱们临床遇到一个感冒，小便不利，这时候发汗白发呀。这个我们在临床

上常遇到，那么他又有个泌尿系感染，他同时也有感冒，这时你别管他感冒，你就给他吃猪苓汤治他泌尿系感染就对了，这个解了，他感冒也解了。你这阵儿要发汗准错，这个要注意。这泌尿系感染就是撒不出尿来，撒一点一点的，次数挺多，没有大泡尿，窝臊子挺疼，里面也有热。他水不行，你发汗没用。

李冠杰：这个条文在《康平本》里是一个降两字格排版的条文。解读一下：这个条文里面也冠以“发汗后”，这个发汗就应该理解为发汗不当，不当在哪里呢？从治疗的方剂，我们可以联想到他这个不当，是因为误发了里有停饮的这种患者的汗。本来在这个经方理论里面，外有表证、里有停饮，像这样的病人，如果单独发汗的话，不单单是表不能解，他还可能会出现其他的一些变证，胡老的说法是激动里水。激动里水也好，加重体液代谢的不良程度也好，总之这是古人从临床当中总结出来的经验，经验经过反复验证以后，慢慢地成为一种治疗原则：凡是里有停饮同时又有表证的人，不要单独的去发汗解表，应该一方面发汗解表一方面祛里水。如果不是经过发汗的出现这种症状也得用这个方法治，对不对？条文说误发汗，不一定没有表证，但是单纯地解表肯定是错的，人出现了新的症状反应，当然这儿还有一个前提条件，完全还有可能存在表证，从方剂上看也完全是有可能的。

出现了新的症状是什么？“其人脐下悸”。这个“脐下悸”通常就是指的小腹小腹，临床当中病人主诉说的小肚子这个地方跳。

后面做了一个解释，这种症状给它做了一个界定，“欲做奔豚”。欲做奔豚是指想要发作奔豚的样子，但是这个不能算是奔豚证。咱们先了解一下“奔豚”，这个奔豚是一个病名，是《金匱要略》里面的一种具体病。但是对这种病的界定和定义不是特别得严谨，不像现代医学分类分得那么清楚。

奔豚汤证和桂枝加桂汤证都算是奔豚病，但是实际上这两种病在病理上相差是很远的，在临床当中表现也差得很多。这个将来等我们

学习《金匱要略》的时候还会给大家说。

电视上有一个奔豚病的新闻报道，这个人因为精神因素，就是他弄死过一条蛇，因为那条蛇特别大，他在精神上就受到了一些刺激，从那儿以后就不定期的，发生很奇特的症状。他爱人说他只要在发病的时候，感觉有一股气从小肚子往上撞，然后就开始难受，难受到什么程度？他家里用铁管弄弯了以后上面用木制的面做凳子，用这个凳子砸自己的头，哐哐的砸，最后把那个凳子的木面都打碎了。你想他有多难受，有时候难受地在床上躺着，躺不住要把头顶在地上，人在床上躺着，人头顶在地上，有的时候就把脚弄到墙上去，人的头顶在床上。大家想想，这就难受到一定的程度了，等这个病过去以后他又好了。大家想想《金匱要略》里是怎么说的？发作起来以后，烦躁欲死，他真的就是特别的难受，这是真正的“奔豚”。而且有一个挺有意思的症状，他每次发病以后，有时候能连续吃二十根雪糕，看来也是有里热了。我当时一看就觉得是这种病。第二次报道的时候，说在省中医院一个老大夫说他就是这种病，让他过来治一治就行了。

这个就属于奔豚汤证典型的反应，但是书上没有说这么具体。桂枝加桂汤到不了这种程度，而且，桂枝加桂汤也治不了这种证。像这一类的咱们就放到学习《金匱》时候再具体讨论。

奔豚具体古人说的是什麼？这个豚啊，实际上说的就是猪，大概那个时期猪的学名叫做豚，奔豚说的也非常形象，用猪的奔跑的状态来形容患者有气从少腹上冲胸咽，痛苦异常，发作时止时发的这么一种证候。古人写些东西值得你去品味，大家想想，像咱们一般的都是成年人，没有动过猪的少，特别是小猪，你要是动它一下的话，它满身都是劲道，它在手里头一抖的感觉，你再想想奔豚，为什么挑了猪这种东西来形容这种病？那真是绝了。

其实我们每个人不一定什么时候，也会发现自己突然觉得小腹部或者说肚子的某个部位，咚咚跳几下，一跳以后觉得挺怪的，整个人

也觉得紧张，对人是一种很奇特的刺激。我想差不多的人都会偶尔有这样的感觉，实际上这就是一种轻症，是这类病的一个苗头。那种感觉还真就是用猪跑的动作来形容，他不仅仅是一个形象的问题，而且特别让人感觉这里边有一种难以用语言来描述的一种意味，挺有意思，用得非常精妙。

这里说的尺度也把握得非常好，“欲做奔豚”就是像要发生奔豚病的那个样子，但是根本就达不到那种程度，不是一种病。

像这样的病就是苓桂枣甘汤主治之证。这个奔豚证，也就是说咱们讨论的苓桂枣甘汤的症状，他这个小肚子跳，因为其他的也可能存在着像有点发热啊，有点汗出啊，有表虚证的那种症状，这个没有什么奇特的，就是说这个小肚子跳。

具体到这个方证上，这个症状从机理上说是由两个方面的原因造成的。一个方面是有气上冲，另一个方面是少腹（小肚子）这个部位有停饮的情况。像这一类病，现代医学也做研究，但是因为我们现在的技术手段还不能揭示这种疾病的物质基础是什么？也就是说这个人得了这样的病，到底哪个具体器官、什么样的组织发生了什么样的病变？找不到。大家看，气上冲，中医为什么把它叫做气上冲，就是因为找不到它的实质性的存在，但是他又有这样的症状。另外一个停饮，在现代医学也有这个概念，也有这方面的研究，但是，相对地说还是比较肤浅。因为人体里边百分之七十几的都是水分，水分的多少还是个动态的，一旦这个人得了病以后，在活体上去研究这个才有意义。一旦这一块组织离开了人体，你再去研究这个水分就没有意义了。所以对这类疾病，现代医学就把它归于神经方面的病。像神经系统，比如说神经官能症，归于这一类的疾病。

但是如果得严重一点，现代医学对好多没有能力搞清的病，都归结为精神类疾病。像失眠，它就给你定一个神经衰弱。那么神经衰弱的机理是什么？不知道。神经怎么着了？要是说它衰老了的话，它衰

老到什么程度？如果说它失养的话，它缺少什么样的营养？现代医学不得讲究这个吗？但是现在没有能力研究到那个程度。所以都把它归结为神经方面的疾病，实际上对它真正的机理了解应该说还不多。

经方对这一类疾病机理的解释呢，不仅仅是这一种疾病了，它都是来自临床实践，从临床实践当中，从能够治好这个疾病的方子当中去分析。苓桂枣甘汤要是和苓桂术甘汤、茯苓甘草汤相比较，你就很清楚了。这个方剂的症状里边就多了一个，关键的不一样的地方就在于小肚子这个地方跳，“脐下悸”，这是一个它特有的一个症状。其他的药物也非常相似，根据这些药物在其他方剂里边所治的症状，整体来分析，你就很容易能推导出来，这就是有气上冲，又有停饮，这么一种情况。

用现在的话在病理上做个界定，咱们不妨就可以这么认为它，就是因为体液代谢障碍与气上冲的共同作用下，而引起的精神方面的一种病态反应。

特别是茯苓这个药，治疗很多神经方面的一些疾病，不仅仅是这个脐下悸，还有心下悸，还包括一些精神方面的不正常的亢奋，它都有治疗作用。所以说我们应该看到，它确实确实是因为有水的因素存在，它也确实是影响了神经方面的一些正常功能。

这一段所论述的经方病理，跟前面我们讨论的那些疾病的症状反应的机理不一样，这个方证是表虚证的同时又有停饮。这个停饮，按照我把它归纳的经方辨证的要素来说，停饮证就是水证，停饮就是水证里边的实证；津液虚就是水证里边的虚证。而且有气上冲，这个气上冲应该属于气证里边的，是气证里边的气逆，这个气逆应该属于气证中的实证。其实，从疾病性质上看也应该算实证，不能算虚证。凡是有表证，误治了以后，仍然有气上冲的，说明人体还有从体表解除疾病的这种趋势，说明人体还是处于一种亢奋的状态。

下边咱们做个小结：对于既有表证又有停饮的患者，如果单独发

汗解表则可能出现其人脐下悸，欲做奔豚的症状，此为茯苓桂枝甘草大枣汤主治之证。

这个方子一共有四味药组成，茯苓半斤，桂枝四两，甘草二两，大枣十五枚。仔细去品味啊，这个大枣挺有意思，在经方里边，大枣一般是用十二枚，合方的根据合方的情况进行调整。有出入的这个方剂是一个，大概黄芪桂枝五物汤是一个，当归四逆汤的大枣是二十五个，但是实际上我们在临床应用当中，十五枚大枣和十二枚大枣，严格地说没有质的区别。另外大枣还有个头大小的问题，要是普遍的都小一点，实际上那三枚枣的量也就出来了。这儿，我的理解和其他的方子用十二枚大枣的，可能不是一家的方子，这是有可能的，也不是什么大问题。这个方剂可以看作是桂枝甘草汤加上茯苓大枣，桂枝甘草汤咱们已经学过了，它在这个方剂当中的作用，就是本方的作用，治疗气上冲，然后实表；茯苓大枣，这两味药的作用，在治疗停饮证的同时还有治疗因为水证而造成悸动的作用，这是大枣和茯苓共同都有的作用。其中尤其是大枣，特别是在这个方剂里边，应该说大枣是治疗“脐下悸”的一个专门的药。因为这个方剂跟苓桂术甘汤，茯苓甘草汤一比较，你就会发现这是最大的一个差别。而且，这个“脐下悸”是这个方剂的最大特点。所以大枣在这方面有它独到的一个作用。

机理是什么，恐怕不是我们现在能够解释得了的，但是这个方剂治疗这个病那是效如桴鼓。别看这个方剂里边没有一味很特殊的药，而且专门用来治疗他这个特征症状的药恰恰是一种食物，是大枣，量也不少特别得大。

这个方剂和苓桂术甘汤和茯苓甘草汤太接近了，都是一味药之差，而且从病理上也是一样的，都是表虚证有停饮，又有气上冲。但是它们各有各的不同，主要不同就在于人体停饮的部位不同。

茯苓甘草汤的停饮主要是胃的部位，苓桂术甘汤不仅仅有胃的部位，茯苓甘草汤主要是心下悸，苓桂术甘汤它是头晕，这个头晕也是

里有停饮，也就是胃中停饮为主要停饮部位的，但是它却常常会引起头晕。这也是一个挺奇特的问题，像这类的问题，我们以后还会进行讨论。比如吴茱萸汤，吴茱萸汤明明就是胃病，但是它会造造成头晕头疼。

但是其他的方面，比如茯苓甘草汤和苓桂术甘汤这两个方剂也非常接近，无论是从寒热上，还是停饮上，就说病理上实际都是一个病理，而且停饮的部位也非常相似，但是茯苓甘草汤造成头晕的机会就很少。实际它们还是有区别的，单说头晕是不是像我理解的，这一类的胃中停饮常常会伴随着大脑部位的体液代谢不好的症状，常常会同时出现。因为人体本身就是一个整体，没法去严格的区分哪一个具体的脏器，就是这一个脏器独立于整体之外，那就没有意义了。

像这一类的凡是有苓桂术甘汤证的人，大脑脑组织里边体液代谢恐怕常常出现一些不良的情况，会造成大脑某种程度的失养，影响大脑新的水分的供应，就会出现头晕。而且这种症状往往和苓桂术甘汤证的胃中停饮是同时出现的，应该说有内在的联系。

下边咱们看看苓桂枣甘汤的方证：这个方剂的临床统计资料医案不是很多，统计到的数据比较粗略，跟当时做这个工作的作者也有一定的关系，他就是写法从简。这个症状统计了三个症状，一个是气从少腹上冲，但这个上冲，实际临床记载也是多样的，有的记载是上冲心，有的是上冲咽喉，有的甚至还有上冲头顶的。第二个症状是脐下悸，第三个症状是心悸。但是气从少腹上冲记载有 8 例，脐下悸只有 4 例，心悸 3 例。

舌质：真正记录下来的只有 3 例舌淡，其他还有 4 例，因为比较分散，也没有明显的代表性，作者就没有给记录下来，把它给省略掉了。使我们无法看到这个统计资料的全貌。

舌苔：以薄白苔为主，就记录这么一个舌苔的情况。

脉象：有脉象记录的一共 7 例，这里边有细脉、沉脉、弦脉，这

是记录比较多的，因为这个脉有的都是复合脉，把它扩展成单脉以后数量就多了。有迟脉、大脉、滑脉、虚脉、小脉、数脉、有力的、无力的。这个脉象比较宽泛。

苓桂枣甘汤所治疗的现代疾病，也就是有应用苓桂枣甘汤治愈机会的现代病：植物神经功能紊乱、胃肠神经官能症、癔病、神经性心悸、假性痫症、神经衰弱、慢性胃炎、慢性肠狭窄、胃酸过多、不全肠梗阻、肾小球肾炎、肾盂肾炎、前列腺炎、心源性水肿、特发性水肿、慢性盆腔炎，这是我现在统计到的，就是说能找到的跟这个方剂有关系的病。

在这个方后注有一个做甘澜水的方法，我们应该说这也是中医里边相对说比较虚的东西，你要说它一点作用也没有吗？古人之所以让你费这么大的功夫去做这个东西，不能说一点作用没有。但是从我们现在实际临床当中用，我们现在已经没有人去做这个水了，把水取上两斗，置于大盆中，用勺子扬啊，直到扬到水面上有五六千颗水珠在上边滚。实际上这就是说，用器皿把水扬起了以后，可以增加水的含氧量，这是肯定的。但是经过煮药，一沸腾，是不是还有这个作用？也难说。至少这一类的起不到关键性的作用，而且不用这种方法，用普通的水煮，疗效依然是很好，所以说意义也不是特别大。

通过学习这条条文，有一个需要延伸的小问题，我们联系第15条，“太阳病下之后，其气上冲者，可与桂枝汤”。这个“其气上冲者”，这一条的“气上冲”，就是第15条里边说的“气上冲”，也就说误治了以后，人体抗病依然有从表解除疾病的这种趋势。但是这儿分出了第15条的内容，发汗不当，也有可能使人体陷于这种状态。

另外，发汗以后可能造成体液代谢不好，本身有体液代谢不好的这种倾向，如果发汗以后，发汗不当的话，也有造成人体的体液代谢不好，有时候其实没有经过泻下，没有经过发汗也有出现苓桂枣甘汤证的机会，现在我们看的都是这个。

发汗后、腹胀满者、厚朴生姜半夏甘草人参汤主之、（66）

厚朴半斤去皮 生姜半斤切 半夏半升洗 甘草二两 人参一两

右五味、以水一斗、煮取三升、去滓、温服一升、日三服、

胡希恕：那么这个地方啊有几种原因，一种这个人原来脾胃虚，那么得了外感了，也得发汗呀，发汗之后常遗留下来这种病。这个腹胀满是个虚胀、虚满，所以不用大黄，不是实满。这个方子治这种病非常得好，这个厚朴生姜半夏甘草人参汤。他因为原来消化不良，那么发汗，我们说了这个津液来源于胃，可是你大量丧失津液也影响胃，互相影响，你健胃呢也生津液，津液大量亡失也影响胃虚，他本来胃就不好，由于发汗之后，产生虚胀虚满发生。

那么这个方子主要是健胃，人参、半夏、生姜、甘草都是行气健胃，去水饮，另外再加厚朴消胀，是这么一个方剂。这个方剂呀，这个病也有时候遇到，不是说发汗之后遇到这么一种虚胀虚满用这个方子，不是的，在临床上常有的，就是个虚胀虚满，这时你按他腹啊没有腹水，没有，但是肚子挺大，咱们说这是气胀。我是遇到这么一个人，这个人从上海来咱们这来看的，这已经好几年了，那还有个石家庄白求恩医院西医大夫跟着我。那个人是上海人，来了肚子是挺大，我看也挺大，我寻思有腹水呢，我让跟着我实习的人，你看看这个人有腹水吗，他检查半天说没有，就是气。我就给吃的这个药。他吃完就好了，他也是多少年就不好。所以这个方剂呀是健胃消胀的药，当然是多少有恶心，你看这生姜用多少？用半斤的分量，有半夏、生姜，哪有没恶心的。他是腹胀满不欲食，有些欲呕，这个时候用这个方子

非常好使。我们方才说了人参是健胃的，这个人参用的量并不大，因为不明显，在胃的这种证候，这个病呢我遇到的就是，并不怎么心下痞硬，主要是上下全挺大挺胀。他吃了3付药，他的腰围下去相当显著，吃几付药就好了，所以我们在临床上有很多的气胀当腹水了，那是越治越厉害，这个利尿是不行的。

这个挺多这种病。不必发汗后，发汗后影响这个呢当然也更行了。所以中医就讲辨证嘛，有这种情况就可以这么用，你象我们方才上面讲这个，苓桂甘枣汤，茯苓、桂枝、甘草、大枣这个药，也不一定在发汗后，凡是脐下悸，或者是少腹挛痛而有奔豚的这种情况，你用它就好使。这个临床上也常用的，所以他这个书啊，这些方剂，那么他讲的是伤寒论了，在这个伤寒治疗的过程上，有些特殊的情况可以介绍，这是一。二一样呢这种方剂呀不在这种情况下，合乎这种方剂的适应证候，你也可以用，哪一段都是的。你像麻杏石甘汤也不一定在发汗后，得病来就是这种汗出而喘也可以用。我们读这个书啊不要死于句下。

李冠杰：这个条文非常得简，在《康平本》里边是降一字格排版的条文。可能是出自张仲景之手。

下边我们解读一下：

“发汗后”，这儿又有一个“发汗后”，这个地方如果说仔细看一看，整个这附近的条文，作者的成分也比较复杂，说的都是太阳病治疗不当，出现的若干个不良后果的处理办法。这地方大部分都是这个，所以，这地方作者的成分也复杂，大家都觉得在临床当中，我有过这样的经验，或者说我在谁那儿找到了一个非常好的方剂，治那种太阳表证治疗不当出现的问题，我觉得非常好，就把它加到这个地方了。就说我们体悟有这样的味道。看《康平本》才有这样的感觉。这儿的“发汗后”就说列举的本方证的病因之一，这也是形成这种病的原因之一。

如果说把“发汗后”跟那个“腹胀满”结合的话，我们可以客观地这么去想，这个发汗的对象，他不一定没有表证，为什么发汗后，这发汗也没有跟你说发汗是对还是不对。为什么发汗了以后他会出现“腹胀满”这样的情况呢？这个人肯定在发汗之前，他就存在着里虚证，或者说有里虚的倾向。按照我们现在的说法就是平素胃肠功能比较虚弱的人。要不然的话一般发汗，你看发汗以后，太阳病不好的，太阳病发汗，发汗以后不好的有的是，这种情况也有，那种情况也有。为什么偏偏这一类的人发了汗以后会出现这样的情况呢？他肯定存在着里虚的情况。

那么再深入分析的话，他之所以出现这种新的变症，就是由于当初治疗的时候这个辨证不够全面，没有顾忌到他的里虚就楞发汗了，只是看到他的表虚，就单纯发汗了。

最后我们会得出结论来：我们可以这么理解，对于有表证同时又有里虚证的患者，这一条讨论的就是误用了单纯发汗的方法才造成的这种情况。刚才我们说了上一条是，我们能体悟到，他上一条是犯了对里有停饮外有表证的人单纯发汗。那么这一条我们能从中体悟到外有表证里有虚证这样的病人，你要单纯发汗的话，也有可能造成不良后果。

那么像这一类的情况，实际上在经方里边也是一个治疗原则。没有具体的讨论，但我们从方剂当中绝对能够看出来。

我在这儿跟大家举两个例子啊：

一个是外有表证里又有虚寒的桂枝人参汤证。曾经有一个学生就跟我打电话，说有个小孩子感冒了发烧还拉肚子怎么办？我说你让他喝点桂枝人参汤吧。喝了以后，后来就跟我说这个方剂真好用，喝了就好了。但是他这个啊，他这个拉肚子你也得去辨寒热。他那个就说有不消化的那个情况，这是外有表证里有虚寒的一个代表性的方剂。

外有表证里有虚热的，它不是虚证吗？咱们现在说的里有虚热

的，外有表证里有虚热的。在《金匱要略》里边有一个竹叶石膏汤。大家去看那个药物，那个药物对的就是这样的人体。就是他又虚又有热，同时又得了表证那个还陷于阴证了，你就得用这个方子。但是那个是在说的产妇，平时我们人得这一类病的机会相对说就少一些。你看很矛盾，因为这个热本身就是一个亢奋状态，然后呢，人又虚得甚至陷入阴证了。就是说这本身就是矛盾。像这种情况，都是一些比较特殊的人群才得这种病。

昨天有一个青岛的学生，他没有时间来我们这个地方参加学习，平时坐诊很忙。他就给我打电话，他说他手上有一个病人没办法，老太太怕冷，现在白天还得穿厚衣服。然后呢，让他治的时候，他前头一直都是按表虚证来治的。后来治来治去呀，就出现了大便和小便都有轻度的失禁的状态。就是如果说出去稍微走一走，回来就不知不觉的有大便出来了。他问我这应该怎么治？我说：现在这种情况其他的都不重要了，所有的目光都去关注里证。他这个里证去辨，里虚是肯定的了，去辨寒热。因为我见不到病人，我就只能给他一个这种原则性的交待，去辨他的虚（寒）热。但是像他这种情况附子是离不了啦。你辨他的寒热。如果说真正有虚热的话，你像有血证的、津液虚的，像生地，就是说补虚的药而且是寒性的，应该考虑的。要如果说是寒证的话，那寒证的方剂就以四逆汤为基础，然后你再去找个有水证涉及水证的方子，有血证涉及血证的方子。但是这个时候他说我给他吃了补中益气汤合上桂枝加附子汤。后来我说你这种方子千万不要用了，那不行，碰到这一类的状态，她已经机能沉衰到自己都控制不了那个大小便的那种程度。虽然说是轻度的，已经到了这种程度了再去用那一类药，特别是像桂枝加附子汤那就是治疗表阴证的。它主要的方向还是来把里边的能量调到体表，来实表的。所以说用那个方剂是很不好的。这样呢，他现在，在调整着用。

“腹胀满”，这是这个方证的一个典型症状反应。这个方证的这

个“胀满”，它是一种气满，按我们的这个用语言来形容就是腹胀如鼓、敲之有声，这是它的典型的一个特点。这个“胀满”呢，你要如果说单纯地从字面上来看的话，你要跟阳明里实证的那个腹满要辨别，也要跟那个里虚证的腹满也要鉴别。

你像它跟里实热证的那个腹满它有一个按之疼和不疼的这么一个问题，你像这个肚子很大，但是你要按他的话他不会觉得疼，他有满的感觉，但是不会疼。然后他这儿有个明显的，就是说肚子里边有气，一敲咚咚的响。像那个里实证没有这种情况。

再一个就是因为里虚寒也会造成腹满，那种腹满像这个方剂呀，它没有那么重的里寒，这是其一。再一个呢，就是说也是一个有气和无气的问题。里虚证肠道里头也不会出现这么多的气。

这个方证啊，归根到底它还是胃肠功能虚弱所造成的。按这个条文的论述呢，就因为本身这个人，他就有点里虚的倾向，或者说，本身就有里虚证。患了表证之后你再一发汗，实际上这个发汗，不是说发汗的要直接去里。而是它，你看这个发汗药的机理呀，就是说把里边的能量往外调，他本身就里虚，你再进一步往外调能量，实际上这是不合理的调度。这样呢，里就更虚了，以至于他发生病变。那么，其实我们现在临床当中碰到的，大部分都是没经过发汗。就是说正常的人他得了这种病，或者说是某种其他的因素造成的。

我碰到过这样的病人：有一个女病人，她说，有一次跟熟人出去吃饭喝了一点酒，第二天就开始肚子胀，砰砰的响，然后挺难受的。她就找到我，我给她一看，我就给她这个方子。她吃了以后，两天以后碰见她。她说你的方子真管用，吃了以后，随着就好了，剩一点药我全部都吃了。她这个呢，就是一个诱因。但是这个诱因呢，大家看，酒本身是一个热性的，但是她就是胃肠功能比较虚弱，平时像一般的女同志喝酒的机会就少，她里边承受不了，就出现了这种情况。

还有一个，我碰到过一个 36 岁的男性病人。你要看那病人就是

说挺壮实，他是跟着别人来我这儿看病的，看完病以后呢。他就觉得别人都说看得挺好的，你就给我看看吧。我就问他，你怎么啦？他就说肚子胀，胀得砰砰的响，说五六年啦。后来我就给他这个方剂，就给了他六天的。他觉得还挺奇怪，他说能好吗？我在好多地方治过，治不好。我说：你吃吃看吧。结果大概吃到 3、4 天的时候开始有一点效，到了 6 天的药吃完了，就彻底好了。后来他给我打电话说，想带我父亲去看病。这也是一个没有任何诱因，而且病程较长的病案。

还有另外一个病人，就因为吃得多了（这个跟大家说过），出现什么呀？既有里实又有这个方剂的这种气胀，既有里实又有气逆。那个挺有意思，就是说你看他的肚子，看着就挺大，然后呢，我说给你做个腹诊吧，按一按他的肚子，他的肚子两边敲的有气，砰砰的响，但是中间一按，中间还特别硬，你要按，他还拒按，你一按他说不舒服，有点疼。那个就给了他是厚朴三物汤合那个厚朴生姜半夏甘草人参汤。就是这个方子，这两个方剂合方，吃了四天，全好啦，包括他的哮喘都好了。

那么，也就是说你无论有没有发汗这种因素存在，只要是出现“腹胀满”，而且是，一定符合这个方证的这种特征的“腹胀满”，他都是这个方剂的治疗的范围。但是呢，如果说真正临床当中，你还要仔细判断他还有没有其他的方证，这很重要。

等你慢慢经方用得熟了以后，有时候可能就用一个方剂来治疗，哪怕是两味药的方子，你也得用它，他就这一个方证，这一个方剂足够了。但是有的时候，我就把一个方剂当一味药，有时候用四、五个方剂合在一块儿。也就是说症状比较复杂，涉及到的方证比较多。

那么这个方证呢，从病理上就是里虚气滞。这个气滞呢，在经方的辨证体系里边，应该是气证中的一个实证。那么这儿呢，如果说仔细来品味的话，这个方剂或多或少的这个方证啊，有一点点偏于寒象。但是呢，不是说很严重。

咱们从病理上就看出来，它里虚又气实。那么这就是一个什么？这就是一个虚实错杂的一种疾病类型。是因为里虚导致了气逆证，也就是气实证。

咱们从药物的组成上，也能看出这个方剂的这种特点出来。从这个药物组成上，能看出这个方证对的。其他的基本上都是补虚的药，但是这个厚朴是一个去实的药，这很明显。因为你有这样的证，就得用这样的药。

实际在经方辨证体系里边，你看我跟大家曾经说过，我归纳那一套辨证体系里边，分了两大类：一类是疾病的类型，分表、里、半表半里，水证、血证、气证。另一类是来界定疾病性质的，疾病性质又分阴阳、寒热、虚实。

我为什么把它这么分成两大类呢？从这儿大家就比较容易看出来。你看凡是疾病类型如果说同时出现的话，那不叫错杂，那叫合病、并病。你像太阳阳明合病，太阳阳明并病。也就是说表阳证和里阳证同时发病，这就是合病。但是你不能说它是错杂，你不能说表里错杂。也不应该那么说。因为它是两种不同性质的东西。但是你像虚实、寒热这一类的，寒热错杂的情况比比皆是。这个方剂呢又有虚实错杂的情况。而且这种虚实错杂，你看这一个，这个方剂这是两种类型之间的错杂，一个是里虚，另一个呢是气实。这两类不同性质的疾病存在着疾病性质的错杂。那么还有相同类型的疾病也存在错杂的，你比如说这个人又有血虚证又有血瘀证，这是我们在临床当中很常见的。那么怎么去理解？就是说他又有血液方面的不足，同时又存在着瘀血。那么治疗时两个方面都要照顾到。但这个相同类型的疾病，两种不同的情况在一块儿错杂着。像这个东西大家可以慢慢地去感悟，你把这些东西分清了，在辨证的过程当中慢慢就会清晰起来。

下边作个小结：发汗后出现腹胀满的，为厚朴生姜半夏甘草人参汤主治之证。

下边咱们看看方剂，这个方剂一共有五味药组成：厚朴半斤，生姜半斤，半夏半升，甘草二两，人参一两。

厚朴在这个方剂中主要起着去气逆的作用，因为它的作用就是行气，消胀除满；生姜、半夏在这个方剂当中呢，健胃祛水；甘草、人参又有缓急的作用，又能补中益气。实际上，生姜、半夏、甘草、人参这四味药，都对胃肠功能有很好的作用。换句话说，这都是健胃的药，对胃肠功能的低下有很好的治疗作用。而且你看小柴胡汤里边，这些药都有。如果说小柴胡汤和这个方剂合方的话，就加上一味厚朴就行了。厚朴的量加得大一点。

如果说仔细看的话，值得我们注意的这个方剂当中，厚朴、半夏、生姜这三味药，药量明显的都比较大，特别是厚朴和生姜，比甘草和人参的量都大一倍以上。而真正有补虚作用的甘草和人参反倒量比较小。这说明什么？这说明这个方证啊，虚证的成分没有气实的成分大。所以说，去气实是这个方剂的主要矛盾点。

还有呢，这个方剂的生姜和半夏，就近乎一个小半夏汤。如果说这人恶心，想呕吐的话，也是这个方剂可以治疗的。

下边看看临床统计资料，这个统计资料总共统计到了 35 例。在症状上，有脘腹胀满的，这 35 例全有，食欲不佳（纳呆）有 18 例，泄泻（腹泻的）有 14 例，腹痛有 9 例，看来这个症状就比较明显了，比较集中，就是脘腹胀满。

舌质：有淡红舌、红舌、暗舌，还有舌边有齿痕的这种舌象。

舌苔：薄白苔、薄腻苔、白苔、无苔。

脉象：细脉、弦脉、弱脉、濡脉、沉脉、数脉。

有应用这个方剂治愈机会的现代病呢，是这样的：慢性肝炎、肝硬化腹水、慢性胆囊炎、慢性胰腺炎、溃疡病、胃下垂、腹膜炎、术后胃肠功能紊乱、慢性胃炎、慢性肠炎、胃扩张、消化不良。

那么这个方剂我想是这样，因为它的症状比较特殊，通过学习这

一条咱们作一点延伸。就说“腹胀满”这个病理，为什么人好好的，他得了病以后，产生了一肚子的气体？你看这个方剂所有统计到的35个案例全都有腹胀满这么一个症状，确切些说就说消化道里边产生了过量的气体。那么消化道里的气是怎么产生的？从何而来？要想认识这一点，但是在这儿说，我不是轻易的拿一个症状推衍个没完没了，一个是它比较典型；再一个这是一个突破口，我们可以举一反三，从这儿认识很多经方病理。

你像我们要认识这个“腹胀满”的由来，就应该全面地去认识人体的消化过程。平时我们说的这个消化过程，相对说比较简单了，特别是现代医学给你描绘了一幅图画，人通过咀嚼以后带着唾液，然后把食物吞咽到胃里边，胃里边有胃酸，有什么酶对食物进行消化吸收，然后又到肠道里边进一步消化吸收。你要说那么去看，我们对人体消化功能了解已经比较全面了，但是实际上，如果说我们换一换角度，你会发现这还都是一些表面现象。我这是从什么地方得到的启示呢？就说去年的时候，中央10套播了一个“海洋的生物”，海底里边的小生物吃什么呢？吃一些海底里边的动物的骨骼。就像有些鱼吃别的鱼，吃别的鱼，大型鱼的鱼骨头什么的，就被抛掉了，抛掉以后沉到海底，海底的一些小生物专门吃这个东西。但是它吃这个东西时很奇怪，它先在骨骼上边制造一些菌，它本身就有这个能力，让它在上面长一些菌，菌长来长去以后，骨骼的质地就被那些菌侵蚀得变了质了，这些小生物再吃变了质的骨骼，它就能吃了。如果说你让它直接去吃骨骼，它是吃不了的。而且这些生物是比较低级的，它就是一条肠子。但是它吃的整个过程，换句话说它的消化过程挪到体外一部分，就是说有一个预消化过程。

我们从这点，再来想想我们人类，人实际上也是这种情况。大家想想我们现在吃的面包、馒头，这馒头我们叫发面的吧。发面是什么意思？以前我们发面用面头，现在都用酵母粉了。酵母粉实际就是酵

母菌。在一定的温度下经过一定的时间，有一定的湿度，酵母菌就会繁殖，繁殖的过程当中，它就在吃我们给它的那个胚基（面粉），它就吃，它消化了以后，产生好多的气体，面团就发起来了。而且经过它先吃过的这些食物，我们再吃，人体就好消化，容易吸收。

那么我们再从另外一个角度来看，前段时间我就跟大家强调这个事，现代医学研究，正常人体身上就存在着数以万计的各种细菌、病毒之类的东西。那么实际上这是我们人类不可缺少的一种东西，你必须得有，你要如果说没有的话，你就不是人了。这么一说可能研究微生物的专家们可能要不同意了，他每天吃饭的时候非常讲究呀，他要消毒呀，然后尽可能离得细菌远一点。但实际上你离不了它，你现代医学已经证明这事了，我们身上有得是。就这一个普通的人，要如果说把你身上的细菌病毒，把它都弄出来称一称，得上斤。这不是我在这里空口说白话，这也是美国的专家最新的研究成果。那么我们不妨就把这些东西叫作什么？叫作寄生微生物，它需要寄生在人体上。

那么这就带来一个问题，这个数量繁多、种类繁多的这些寄生的微生物它在人身上，它们互相之间就有一个制衡关系，哪一样也不能无限制地去繁殖，但是哪一样也不能少了，基本上就是这么一种状态。在总体上形成了一种相对稳定的这么一种比例关系。而且这个人和这些寄生微生物之间实际上是一种共生的关系，人如果说没有它你也活不了。下面我们会说到，其实你人就离不开这些，咱们现在不是叫有益菌嘛。但是实际上有益菌和咱比如说就跟我们生活当中，目前这个季节最让人讨厌的就是蚊子，人人都喊打，人人都讨厌它，人人主观上都想世界上没有蚊子多好，但是要真正没有蚊子，吃蚊子的东西就要死掉，那么吃它的东西又要死掉，这样到最后要危及到你人的生命，这是整个的一条生物链。

所以说这个人体上你也离不开这些东西，那么也可以说有这些东西的存在，这才是一种正常的，要如果说都在正常范围之内，这才是

一种正常的体内的生态环境，这就叫生态环境。这才是一个完整的生物链，我们人体体内也有一个完整的生物链。我们人体正常的内环境就是以这些微生物的存在为一个条件的，没有这些微生物的存在，我们的正常的人体内环境也没法维持。它是维持我们人体体内的一些，或者说我们说维持正常秩序不可缺少的一个物质基础。人缺了这些东西不行，这些东西没有人体它恐怕也会少一个很重要的生存场所，恐怕有的离开人体以后真找不到更合适的环境。这个事呢就相对说没有人对它的依赖大。你像有一些菌离开人体以后，比如它在猩猩身上，这是我们能想象到的就是跟人的基因绝大部分都相似，它在猩猩身上能生存，但是如果说我们人没有我们身上这数以斤计的，以万种以上的这些各种病毒病菌的话，你反倒是没法生存。

而且进一步地说，一旦这些东西之间发生失衡，就是说比例发生了比较大的变化，由量变发生成了质变，那么直接的后果就是人得病了。也就是说人体内环境没法维持了，你就得病了。那么维持这些东西，是你人体状态好，就能维持它的正常状态。

我们回过头来再看看我们这个消化过程。这个人摄入就是人吃了东西以后，绝大部分的食物都不是直接消化的。咱们现在吃的这个发面的东西是一个最典型的一个例子，你在吃这个面粉之前，也就是说你在吃这个小麦之前，它已经在你的体外，你的消化过程已经开始了，就那个酵母菌已经开始帮助你消化了。那么我们吃到肚子里边以后，除了现在知道的有胃酸有胆汁还有诸多的酶，实际上这个酶来源就比较复杂了，除了这些东西帮助人体消化以外，还有各种所谓有益菌的参与进来。那么确切地说，人吸收的营养在很大程度上是这些所谓的有益菌先消化以后的代谢物，话很难听了，不好听，但是这确实是事实。我们肚子里面就是满是细菌，这个已经不是什么危言耸听的一个，这不算是谣言，这是事实。那么这些细菌在干什么？它就在做这些事。

正常情况下这是一个很和谐的平衡状态，如果人体的内环境发生

变化了以后，它就势必会对这些所谓的有益菌产生一定的影响。那么换句话说它们的生存环境发生了变化了。那么发生了什么变化呢？消化道以内某些在生存过程当中，产生气体比较多的那些细菌的数量，让它的数量增加的因素增强了，那或者说呢，是抑制这一部分细菌的那种另外的菌的生存环境变差了，它们的能力下降了，抑制不住它，不管是哪一方面，最终的结果就是因为造成了这种它生活在体内它本身就产生好多气体就跟我们发面是一样的，类似，但不一定是这种酵母菌了，它不定是哪一种菌，这种菌呢，它在肠道里的生存过程当中，它就产生气体产生的比较多，但是呢这个时候恰恰是它无限制的开始繁殖。因为它生存环境变好了，或者说是抑制它的那个菌的那个生存条件变差了，抑制不了它了，那么它就开始超量的繁殖。超量的繁殖就超出它的正常值，这个时候它就产生了很多的气体，于是我们消化道里面这个气体就变得多了。那么肚子就腹胀满，敲起来当当的，就是那个噎噎的气胀的那种，就是这么来的。

那么对这一类的情况，我们为什么绕了这么大一个弯子？就是想让大家明白一个道理，治疗这一类的疾病，你最好的办法是什么？以恢复人体的这个环境。因为人体的环境不管受什么因素的影响，条文里说的是发汗，刚才我还和大家说了一个饮酒，那么有的人还有泻下。不管哪一类的因素影响，造成里虚以后形成了这么一种环境，你把这种环境恢复到常态以后，这个菌之间慢慢又恢复了它以前平衡的那种关系，该抑制的抑制，该发展的发展。那么咱们这个方剂就是厚朴生姜半夏甘草人参汤，它恰恰就有这个功能，恰恰能够对这个产生这种病态环境的这种人体内环境它有一个修正作用，它就能治好这种病。

那么我们再延伸一下，实际上大家如果再举一反三的想的话，经方里面很多的方证、很多的里证都有这一类的问题。理中汤就没有这一类的问题吗？不一定，恐怕也都有这一类的问题存在。

那么我们在这人体就不妨得出一个结论来，经方所有的方剂都是

通过调整人体的内环境，来实现治愈疾病的这么一个目的。

那么要这样呢，我们再去返过来温习一下，在学习条文之前，我曾经跟大家说的。我们应该怎么样来理解经方这一套理论？那么我们就完全可以得出下面这些结论，在相同的人体病理环境下，可能在不同的人身上，应该说在不同的人体上，就有可能在不同的器官、不同的部位，发生性质完全不同的疾病。比如说两个病人同样都是半表半里有虚热证的这个小柴胡汤证的这种病理环境，但是在甲身上可能是胆囊炎，而在乙患者身上就有可能是肺炎。但是呢，他们的人体的病理环境是一样的，所以说要用一样的方剂来治。那么反过来再说，在不同的病理环境下，同样在不同的人体上，则有可能发生这个病变部位和疾病性质完全相同的疾病。这个咱们其实前面讲过例子，那个反过来就行了，以同样的比如说一个是吴茱萸汤证、一个是小柴胡汤证，但是这两个病人有可能得的都是乙肝，都是乙型肝炎。但是它却是两种不同的病理环境下得的这种病，你要用不同的方剂来治。

那么这样，我们就清晰地看到了另一点，就是经方医学治疗疾病的对象，恰恰治疗的是什么？是造成各种疾病的那种病理环境、人体的病理环境。这是经方治疗的。经方不去治疗那些具体部位的具体疾病，当你把这个结论接受了以后，你再回过头来再看看经方条文，你就会明白，为什么经方里面不强调具体的疾病，不强调具体的病变位置，甚至不强调脏腑，这就是他的道理所在。而且经方治疗的这是什么呢？就是我们现在说的病理环境。这个病理环境，恰恰是我们现在全人类正在努力寻找的造成各种疾病的真正的原因。

就像去年德国那个腹泻一样，人们都在找为什么？这个病，这种病菌哪来的？就是你人体的内环境发生了变化了，抑制它的能力不足了。你到外头去找你能找的着吗？但是经方医学在这方面已经形成了一套非常完整的医学体系。这也正是经方医学和人类其他任何医学所存在的质的不同。

那么说到这儿，咱们是从一个疾病的具体的症状，这么一步一步的深入，一步一步推导过来的。等我们推导过来以后啊，我们就发现，实际上这一套道理并不复杂，而且治疗的方法也在那个地方。那么为什么这个经方历经了这么多年？经方，你看经方像我们看的《伤寒论》是有史以来我们能够见到的最古老的方书，比它更早的基本上没有。那么既然有了这么长的历史，它的疗效又这么好，理论体系又这么完整，那么为什么得不到普及？这是一个现实，我们不能不去正视。

为什么会得不到普及呢？要如果说想真正解释清楚这个问题啊，这是非常复杂的事，它涉及了很多方面——涉及了社会、文化，等等，涉及了很多方面。但是我们这地方，我们只强调跟我们直接有关的。其实啊，它根本原因在于什么啊？就在于经方理论啊，它高于我们人类对事物的一般认识。所以说啊，它直接的后果是什么啊？就是说绝大多数人都用一般的认识来误读经方理论。

那么这句话怎么理解啊？大家想想看，你看啊，我们直到现在，你去看所有的历史上对经方理论的解释，从张仲景，也就是说我们现在知道的史料，从《汤液经》，《汤液经》以后出了个张仲景，从张仲景以后又出了一个胡希恕。很怪！这是一个客观现实。就是说像胡老这么理解经方理论的，从有经方书一直到现在，除了日本人的观点——因为他们不受其他一些中医理论的影响，他们有一些观点比较接近以外，但是有人说胡希恕的理论是从日本人那里学来的，实际上不是。胡希恕之所以能够取得现在的成就，就是因为有一个非常有利的一个条件，就是他一学中医就不是脏腑辨证，这一点很重要！要不然的话，就是说脏腑辨证是什么？脏腑辨证也都是事实，就跟现代医学一样都是事实。你比如说，他说肝火旺了，你用现代手段化验了以后它就是肝炎，你只要辨证正确它就是事实。但是这个事实，如果说跟我们刚才讨论的经方的理论相比的话，它是不是就浅了一个层次？恰恰就浅了一个层次。所以说，经方的理论它就高出了人类对事物一般

的认识。它恰恰就高这么一步。实际上高这么一步，就跟那个爱因斯坦“相对论”一样。爱因斯坦“相对论”。我们一般人都整天在想，我这一个尺子是个“十个厘米”，十个厘米我拿着它，这是一个标准，我拿它去测量别的东西，很少有人再去想，这是一个尺子如果说以光速运动的话，它会有变化吗？很少有人去想这个问题。那么经方就是此类性质的问题。

我跟大家说一个咱们生活当中比比皆是，大家都最常见的一个问题。你比如说咱们现在电脑上的这个输入法，你看学电脑，人机交流很重要的一个途径，除了鼠标之外就是键盘、操控键盘。现在电脑这么普及，那么用电脑的人越来越多，那么操控键盘最好的办法就是标准指法，这个毫无疑问，因为我们键盘就是，你现在没法改变了。那么就是说这种标准指法，十个手指头全用。这个事是显而易见的，谁都知道，但是就是这样有一些专业的人士还恰恰不用标准指法呢。我就看一些，有一些电脑公司的职员看着速度也不慢，但是说他那个不慢是有条件的，他就二指禅。那个你现在包括一些西方发达国家有时候报道一些新闻的时候，你再看它的一些专业人士，他在电脑前操作的时候他也是一个手指头在戳，也是一指禅。那么为什么呢？包括标准指法和盲打，要如果说你真是沉下心来练习的话，七天足够了。一天两个小时，你有七天时间完全能掌握，只要是智商一般，能说的过去的人，完全能掌握。就这 14 个小时，为什么那么多的人他天天用电脑，他就不去逾越这 14 个小时呢？大家去想，这是一个事儿。

另外一个就是说咱们这个汉字输入法。这个汉字输入法倒退到三十年以前的时候，在全世界这是一个世界性的难题。怎么能把汉字输入到电脑里边去？后来慢慢地，真是这是人类的智慧啊，慢慢地有了，不但有了方法输入进去，而且能把这个就是说像雨后春笋一样出来很多的办法。出了这么多的办法，现在恐怕得上百种，就是说汉字输入法各式各样的版本。可是所有的这些汉字输入法里边，最慢最不好用

的，就是拼音输入法，而且，现在用拼音输入法的恰恰是人数最多的，这可不是一个偶然现象了。那么为什么啊？

还有再进一步就是说五笔输入法，五笔输入法是汉字输入法里边可以说是最难学的一种，但是却是在人们心目当中它却是最专业的。你看这就奇了怪了！就是你现在你说什么都不能改变目前这个现实，这是一个现实。那么可能有的同道就问了：“那么你说最好的输入法是什么”？我在这儿我不是推销输入法，而且我也不是说我用什么输入法，什么输入法最好，不是啊，这是事实，跟我用不用没有关系。真正最好的输入法是二笔输入法，就我现在用的输入法。

那么这个二笔输入法不是我自己在说它好，我用它是误打误撞，我当初是学五笔，我真的我没有那么大的精力去背那三百多个字根，然后学拼音我都把拼音学成了，然后用得也挺熟了。然后我发现你用的越熟了、学的越熟了，你感觉它越慢，因为你要重新再挑字。后来，我是偶尔碰到这个二笔输入法，那段时间我是比较清闲，我就看看这不挺简单的嘛，我就开始用它。用来用去，到后来我才知道这是可能到目前为止啊，我们中国唯一一个在国内获得国家认证的一个输入法。国家认证不是一个小事，那都是说这一行里边所有那些专家对它进行全面地测评。这个输入法它的广告语是什么？就是“十分钟学会，永远不忘。”你看它这实际上就是对着那个五笔啊，因为五笔它是一段长时间不用它就忘了，这个它不会忘的，它这套东西很科学。

但是用它的却是可能是在输入法里边不能说它是最少，到后来国家推广这个东西，就是说据说是南方到广东里边的小学、在小学里都在学。就是这样你也推不开，这就奇了怪了！为什么？我那有一段时间，那时候我在济南，在济南、在北京的时候，我都是只要是有机会跟别人聊到这个东西，我就跟他们说二笔输入法多么好，然后我就拿一张纸，因为这个东西挺简单，我就拿一张纸画一画。谁一接触都会觉得很好，但是我真正教过的没有一个使用的。后来我就觉得我是不

是我太笨了，我这种就是说传授方式不好？到后来我仔细一想：不对。因为国家的推广也推广不开。为什么啊？因为这个输入法有一个缺点，可以说是一个致命的缺点：它是你得先打这个字的第一个字母，也就是说这是一个读音，是个音的；第二码的时候它打的是这个字的前两笔，也就是说它是个音形码。所以说你在打的时候，刚开始用的时候，还形不成条件反射，觉得很别扭。先要想这个字念什么？然后再想着它的第一个字母；然后第二码的时候又要想着这个字怎么写？跟特别是要你告诉这个人“十分钟学会，永远不忘”。他就觉得我十分钟以后就会成为高手了，结果他一用，感觉不是那么回事，挺别扭。懂很容易，但是用起来很别扭。就这么一点差别，造成了什么？造成没有人用，几乎是，就最后结果就会这么严重。当然就是作为一个输入法来说，这不是什么大问题。你一个人在用，你不会影响别人。

但是如果说是医学的话，大家想想问题就严重了！你用了不是一个最好的医学，不是最完美的医学，不是反映事物本来面目的医学。它能不出问题吗？

但是，咱们这个历史走过来以后，经方现在已经到了几乎没有人用的这种程度。所以说这个经方的普及真是任重道远啊。但是我想不管怎么样，它毕竟是一个治病救人的科学，我们有理由要相信它这个规律迟早要被人类医学界所接受。就跟什么啊？就跟那个牛顿力学里边那个“第三定律”一样：“作用在两个物体之间的力总是大小相等，方向相反”。这个特别是我在学校的时候，学生们之间讨论最多的事——它怎么可能“大小相等、方向相反”呢？那么两个拳打在一起，有个人疼得厉害，有个人疼得轻，它怎么能会是相同的力呢？你理解不了没有关系，你必须得接受，这是一个现实。你不按照这个现实去做，你的实验就成功不了，它就得不到你想要的结果。所以说这是一个自然规律。经方就应该，最终应该是这样的一条路。

所以说我觉得经方迟早应该会普及。但是呢，就目前来看啊，客

观地说经方确实始终是在一个很小的，在中医里边也是在一个很小的圈子里边。我记得大概是四、五年以前吧我见过北京的有一个人，写过一个，他写了一个小帖子，他说他的一个邻居是个医生吧，但是就在家里边看病，但是疗效很好，病人也挺多，但他觉得很羡慕，他经常找这个人聊。他说：“我对中医很感兴趣，能不能传授传授我？”后来这个老大夫就给了他、就建议他说：“你啊，要如果说真想学中医，什么书都不要看，你就去看《伤寒论》，就看这一本书”。当然说的绝对，也许他是对的。所以说啊，这个老大夫肯定对经方有自己比较独到的见解。

但是我想啊，好的东西，它生命力非常强。你就像经方吧，前两天有一个学生过来了。来了以后他就说：“我现在身边的这些医生都是用时方随证加减，然后我就跟他们聊，我说我现在学经方，用经方去看病”。人家嗤之以鼻，然后就说：“现在哪有还用《伤寒论》上的方子治病的”？都嘲笑他。到最后他都没法跟别的医生交流，这也是现实。

但是我觉得既然到了这种地步，可是经方依然被整个中医界称为中医里边经典的经典。为什么？这就反映了它一个超强的生命力，对的东西、真理是不会被磨灭的。

在这儿跟大家说这些，就是为了能给大家打一打气，希望大家能够持之以恒地把经方学好，你肯定会受益无穷的。

上一次跟大家说了个关于那个就是发了疾病那个老头，若中医你说救急啊，救急以后你像他特别是像柴胡证，他不可能就是说当时情况是稳定下来，那不可能就说你吃了一次药就好利索了。那么他又到了，我就给了他等于说一天的药，就给了他第二天服的。那么到了第二天的下午吧，然后他又找我，他就说：“能上班了”。就是说稳定住了，但是肠鸣、噎气，胃中很不舒服，就是说还有好多不适吧，然后那些柴胡证都有。这样呢就是说他现在情况稳定下来了。那么我

就给他什么方剂呢？小柴胡汤合上半夏泻心汤、旋覆代赭汤、吴茱萸汤。但是大家可能听着这么多方子合在一块，你要是如果说仔细算一算的话，其实就是小柴胡汤没加几味药：小柴胡汤加了一味吴茱萸，加了旋覆花、代赭石，然后又加了一点干姜、黄连，其实就这么一点药，基本上还是小柴胡汤的主方。我给了他是三、四天的药吧，结果第二天开始下大雨，那个他把药拿走以后，其实那天晚上就开始下，那雨挺大，到第二天没见到他，而且我看到是另一个清洁工在打扫卫生。哎呦！我就是说，一般地说他要如果说症状特别明显的时候，一般的方剂出去以后你会觉得心里比较有数。但是这个有数如果你像这种情况你见不到他了，他又这么大年龄，心里也在想是不是有点什么情况？结果过了两天他过来了。我问：你怎么两天没过来啊？换别人了？然后他就说他那个村里边雨大的有一些房子都倒塌了，然后就出不了村了，结果还是就换了别人。他来找我呢就是说基本上就是症状都不太明显了，问我这个药是不是一天还喝一次，那么我就告诉他可以喝一次，多喝一段时间，年龄那么大了，这个病呢长期带着不好。这样这个事呢基本上了结了。你像他初喝的第一天大便多少有一点不成形，那就是说旋覆花、代赭石的事，第二天就好一些了。以后呢再根据他的症状，你要如果说这个药还没服完，也许服完了以后啊最后就剩下小柴胡汤加再一点吴茱萸，吃一段以后他就会好很多了。

这是跟大家说的医案，因为前一段时间跟大家说的时候，实际上他第二次药已经拿走了，但是他没有反馈信息，我就没法给大家一个完整的一个交代，他这个基本上就算是医案从头到脚、就算是完整下来。

伤寒若吐若下后、心下逆满、气上冲胸、起则头眩、脉沉紧、发汗则动经、身为振振摇者、茯苓桂枝白术甘草汤主之、（67）发汗病不解、反恶寒者、虚故也。芍药甘草附子汤主之、（68）发汗若下之、病仍不解烦燥者、茯苓回逆汤主之、（69）发汗后恶寒者、虚故也、不恶寒但热者、实也、当和胃气、与调胃承气汤、（70）

茯苓桂枝甘草汤方

茯苓四两 桂枝三两去皮 白术 甘草炙各二两

右四味、以水六升、煮取三升、去滓、分温三服、

芍药甘草附子汤

芍药 甘草炙各三两 附子一枚炮去皮破八片

右三味、以水五升、煮取一升五合、去滓、分温三服、

茯苓回逆汤方

茯苓四两 人参一两 附子一枚生用去皮破八片 甘草二两炙
干姜一两

右五味、以水五升、煮取三升、去滓温服七合、日三服、

调胃承气汤方

芒硝半升 甘草二两炙 大黄四两去皮清酒洗

右三味、以水三升、煮取一升、去滓、内芒硝、更煮一两沸、顿服、（注）加减方非疑仲景方

胡希恕：第 67 条：他搁个伤寒，伤寒就是无汗的这种太阳伤寒

了，依法当发汗呐，是吧，不能够吃吐下的药，“若吐、若下”都属于误治。那么这种误治，表不解，气上冲。那么里有停水呢？那么非挟着气上冲往上犯不可，所以“心下逆满，气上冲胸”，由于原来是太阳伤寒，你吃泻药，他表不解，气上冲，所以气上冲胸。那么携带着水，那么心下，就胃这个地方呀逆满。

你这个吐下，我方才讲了，都伤胃气呀，胃虚，这水就往胃上来，所以心下这个部位感觉逆满。这逆满这两个字搁得很好啊，满是满，逆是从下往上来。“起则头眩”，一动作脑袋就要晕，这是胃有停水一个主要的证候，胃停水呀头晕头冒，脉沉紧，这就是里有水呀脉沉紧，咱们讲《金匱》就有了，说里有水饮，这个脉大概都沉，脉搏如沉，当责有水，就是进胃里头。紧呢？紧也主饮主痰。脉沉紧就是里有寒饮。本来这个病啊也是里头有停水，那么大夫在伤寒这个阶段给吃泻药吃吐药，这全错误的，那么影响气上冲，水也伴着气上冲，所以心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，这个证候。

这个病怎么治呢？就应该用苓桂术甘汤。苓桂术甘汤就是桂枝甘草降冲气呀，咱们头前这个方子。加茯苓、白术呢就是利尿，就治了。

“发汗则动经”，这更不能发汗了，你看这个他也照顾这一点，我们方才说了里有停饮不能发汗，他这个本来是伤寒，他吃了吐药吃了泻药，气上冲，说明什么呢？表没解。表没解得解表，不是吃发汗药嘛？可是这个情形啊不能吃发汗药，非利水不可。所以根本呐就应该后面这个方子就是苓桂术甘汤，吃这个就对了，哎，这再发汗啊错上又错了，是表未解，表未解你利水治其气冲，这表自然就解了。要是发汗的话，则动经，使着这个水毒，咱们说水邪了，动悸经脉。这怎么讲呢？我们发汗，也是夺脉管里的血液，可是呢我们身上内里头有水，水借这个机会也渗透到脉管里去，你要不发汗这个问题不大，咱们讲这个调协营卫呀，营卫不和，一发汗使它们调和。那么假设有停水的话，一发汗，那么使着水毒啊必乘虚而入到经脉里头去，就指着血管

说的，所以说发汗则动经，动经就是动悸经脉。

“身为振振摇者”，动悸经脉了，就是身上振振摇，就是战振而摇摆，“苓桂术甘汤主之”，这怎么治呢？也得用这个药，用茯苓桂枝白术甘草汤。这个同上面那个方子全是由桂枝甘草汤加味而成的，那个加茯苓、大枣，这个加茯苓、白术，那么这个利尿的作用比上面那个有力量，因为有白术了。但是治这个悸烦不如上面，上面那个茯苓用量是独多呀，你看那茯苓用多少，那个茯苓是半斤，这个茯苓才4两。可这个就因为头眩晕得厉害，胃蓄水多，他们说白术健胃健脾呀，这东西也不能这么看，胃里要停水呀用白术非常好，如果这个胃拿现在的话说发炎，有炎性的病变，而且没有水，这个白术是有害而无益，白术这个药是温性药，据西医说也是有一种刺激性挥发油，能够刺激胃粘膜充血，要是发炎吃了更坏，所以古人用这个药，胃停水就是胃虚有寒嘛，水性寒嘛，所以你用白术就对了。不是这个健胃药遇到胃病就可以用的，不是的，他这个是胃有停水而气冲、眩晕，心下逆满，气上冲胸这种情况，用这个方子，这个方子也常用的很。不是发汗后，不是吐下后，我们在临床上一般的头晕多属这个方子，尤其心跳，心跳、头晕，小便有时候也不利，但是不很大明显，那么这个方子再加上泽泻挺好。

如果有贫血的这种情况，贫血还头晕啊，也有这个方剂的情形，你可以合用当归芍药散也行啊，当归芍药散合这个方子，尤其女同志最多，头眩晕，有些贫血的现象啊，经血不利呀，你可以用苓桂术甘汤合当归芍药散。这个方子最常用，你不能单独守这个方子用，可以随便加减，你要是加上泽泻呢，那么就是泽泻汤与苓桂术甘汤的合方，泽泻汤就是泽泻和白术两味药，我一般不用白术，用苍术，这我在临床上有个体会，这个白术不如苍术，古人不分白术、苍术，那么后世给分了，现在在临床上我觉得苍术要比白术好，白术好像有点燥似的。这个方子也常用得很，一般头眩晕，没有其他的病变，所以古人有句

话“怪病当问水”，这个神经官能病啊也是有停水的关系多，所以他无故眩晕，嗯……这类的病啊大概都是停水，气上冲，这个多。如果有恶心那就不行了，恶心那就是吴茱萸汤的那种情况，不恶心这种头晕、心跳，大概这个方子都行。

李冠杰：这四条（67、68、69、70 条）如果仅仅读文字，大家可能还没有明显的感觉，因为这些文字可能好多同学差不多都能背。因为条文都在康平本里，宋本把它分成四条，相对说都比较简单，但是当看到《康平本》它是一条文字的时候，我们就得重新审视一下。它是不是有着什么内在联系？它与同一条分成四段有什么样的区别？我们先把它整段的粗略解读一下，然后我们再一条一条地具体解读，最后我们再把它合到一块回顾一下。

这一条整体来看，可以知道它主要围绕着“伤寒”，前面不是说伤寒嘛！也就说太阳表实证经过误治以后发生的诸多变证，就是围绕着这么一个主题开展的。虽然我们不止一次地说，在经方理论里重证不重病因。但是这种强调病因的论述方法，在经方理论里比比皆是，非常多！那么他的用意其实不止一次地说过了：既能节省文字，又能借助于具体的病因来帮助读者去深入理解各个方证，就这个具体条文来说，理解各个方证的病理是怎么来的。如果没有这个病因在前面，要把这个病理叙述明白是一个相当复杂的事。有病因在这儿，就比较容易理解，自己想都能想出一些头绪来。

这个条文前边的“伤寒若吐若下后”，实际上是这四条的一个总纲，是总的病因，它是后边四条总的一个基础，这一点很重要。如果把它分开的话就没有这个概念。整体的理解这个条文，它就是说对阳性表证误用了攻法（吐、下都是典型的攻法，后面还有汗法），它出现的各种变证和相应的治疗方法。如果表实证出现这样的情况，可以用这种方法治疗；如果是表虚证用了这些治疗，出现的也是这样的证，同样的也可以用这种方法治疗。事实上没有前边这些病因，如果是这

个方证也应该用这个方法治疗。但是如果没有病因在这儿放着，那么论述这个方证就要复杂一些。

还有一个问题：它前边特意举了两种误治的方法，一个是若吐、一个是若下，这都是攻里的办法。为什么集中强调攻里的方法？实际上这不一定局限于吐和下了，比如像火攻如果出现这种情况，也可以这样治。在这儿强调吐、下的用意是什么？是因为这些治法最直接的后果是导致虚其里，容易发生里证。“伤寒若吐若下后”在条文中还有言外之意，如果用攻里的方法对阳性表实证进行施治，常常导致条文里论述到的各个方证的情况出现。换句话说，这儿列举的是一种表证经过误攻里以后容易出现的变证。

下边我们一条一条地来看：

“伤寒若吐若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白术甘草汤主之”。

这一类的情况前边实际上不止一次讨论过了，太阳病误治以后，误吐也好，误下也好，或者吐下兼用也好，它无非出现三种情况：一个是表证仍然不解，应该属于桂枝汤之类的方剂所治疗的范畴，也就是说不能再发汗了（因为后边几条都有发汗的方法，那也是误治）；还有一种情况是自愈，就是我们学过的第 58 条论述的情况，误治以后它也有可能自愈，自愈了就不要管它了；更多的情况是这条论述的，发生了其它的变证。这一条就是出现了变证之一，就是表证误用了攻里的方法，之所以把它排在前边，因为这也是一个常见的变证。

它具体表现为什么呢？“心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧”。这条在经方论述中是症状比较全的一个条文，实际上就形成了一个特定的症状群，也就是成为了一个特定的症状范畴。尽管是这样，如果想理解这些症状的病理，还得要结合治疗方剂来分析。为什么呢？咱们具体地看看这个方证，它本身属于外有表证，里有停饮。刚才咱们说了，前边学过的条文里就一再强调这个治疗原则：表证误下

误吐以后，如果出现表不解的话，就得用桂枝汤来治；如果表不解，同时又有停饮的话，只用桂枝汤治就不行了。这个方证就是这类的情况。我们可以这样理解：原来这个人是表证，误治了以后出现了苓桂术甘汤证。为什么呀？这里边有一个很客观的原因存在，这个人本身就有停饮的倾向，具体到这个条文里，也有可能是因为误吐误下以后伤到了里，造成停饮。有没有这个病因不重要，但是他已经发生了停饮了。一般误吐、误下的条文很多，为什么偏偏这个方证趋于停饮呢？就是因为这个人本身体液代谢有不好的倾向。

再来看看具体的症状，“心下逆满”这个症状在很多方剂里都可以见到，但是病理不一样。比如说理中汤有可能见到这个症状，理中汤有时候会吐啊，它是属于胃虚寒，吃进去的东西消化不了；半夏泻心汤也有可能出现这种情况，半夏泻心汤跟理中汤的心下逆满这个症状差不多，心下就是指的胃口了。但是苓桂术甘汤的心下逆满跟它们的不一样，同样都表现为这个症状，苓桂术甘汤证的心下逆满是因为胃中停饮，同时又因为本来是个表证，误下了以后还没有彻底的离开在表的病理阶段，人体还有自表解病的这么一种趋势存在，同时又有停饮的情况发生，这个时候还有气上冲，气上冲和胃中停饮这两个因素结合到一块儿，就会造成人心下逆满的感觉。

第二个症状“气上冲胸”，相对地就比较简单了。刚才那个病理不用去重复了，就是说人体还有从表解的趋势。但是“气上冲胸”在其他方证里也能见到，比如桂枝加桂汤，气上冲胸在这里边应该算是轻症，不算重的了，就有这种感觉。但是从病理上来说，桂枝加桂汤是单纯的气上冲，没有停饮的情况。

下边呢“起则头眩”，这个也不是苓桂术甘汤方证特有的症状，比如吴茱萸汤证就有起则头眩，当然吴茱萸汤还伴有吐，有时候也不一定吐。所以说经方辨证难，你把握不准、吃不透这套理论，这些东西就慢慢把你搞晕了。“起则头眩”也不是苓桂术甘汤专有的一个症

状，但是“起则头眩”却是停饮证常见的一个症状。咱们有必要对头眩这个症状的病理做个剖析，尽管我们不像现代医学那样对物质的微观研究得那么具体，数据那么详细，但是中医认识的东西用现代医学的技术还很难把它认识清，认识不到，没有那能力。这些东西都是从临床实践中把很多的病例联系到一块儿，经过分析以后推理出来的，再返回来指导临床，能被实践所证实它是正确的。

我们首先应该弄清一个问题，并不是所有的停饮证都会出现头晕，这是很明显的事。再进一步，也不是所有的像苓桂术甘汤证或者真武汤证这些患者都必然会出现头晕，也不一定。这就有一个问题，既然是没有一个很固定的规律，那么肯定还有其它的因素存在。所以说头眩头晕除了停饮这个前提因素之外，还有别的因素，我们常强调一个事儿就是人体的不均衡性，由于人体有这样的一个特点，那么只有在人体的脑组织处于停饮的最薄弱环节的时候，才有可能因为停饮造成头晕。咱们中医理论里对好多的人体脏器都了解得相对比较深入，这是一种宏观的，比现代医学那种深入到细胞的层面，甚至更微细的层面去认识有一定的优势。但是唯独对大脑的认识，在这方面的论述相对地说比较少，不是很多。所以我们不妨可以这样想，人之所以头晕，是因为在整体存在停饮，也就是体液代谢不好的这种因素的前提下，人的大脑部分也处在停饮的薄弱环节，也是停饮的一个重灾区。要是这样理解的话，好多情况就可以顺理成章的解释通了。比如舌诊的时候，你会注意舌质上有没有齿痕，我曾经和大家交流过，如果这个人有齿痕，他绝对有停饮的因素存在，但是要没有齿痕，不一定没有停饮因素存在。为什么呀？因为有可能舌体这个部位，由于人体的不均衡性它不停饮，你就看不到齿痕，但是不一定其他的部位不停饮。只要明白这个道理，再细想就容易明白了，大脑有时候也会有停饮的，当大脑停饮的时候，头晕的症状就会凸显出来。但是，胃部停饮往往会造成头晕，也就是说胃部停饮往往和大脑头部停饮会同

时发生，这种机会比较多。从经方的实际临床统计资料看也是这样，这类方证有头晕的症状占的比重是比较大的，特别是吴茱萸汤证，或头疼或头晕，但是所有的药都是治胃的，这是一个很明显的例子。

怎么会出现这种情况呢？再往深了说就比较复杂了，你看现在有一个所有医学都解释不通的问题，现代医学认为大脑是精神活动的主要场所，但是经过深入的研究后，发现人体的腹部有一千亿个记忆细胞。那么记忆细胞长在腹部干什么？人体是个有机的整体，从治病的角度上古人总结了一个经验，就是说人体胃部停饮的时候，往往会伴有头晕的情况。我们在临床辨证的时候，比如病人主诉头晕，你首先想到的就是有没有停饮，然后再去找停饮的其他证据，或脉象，或舌象，或其他的症状，再去找这些证据。没有证据那也形不成停饮，它还有可能是其他方证。所以说中医讲究的就是证，说到这儿大家会发现这个证不是一个个孤立的症状，必须是个有机的、有内在联系的，你光有头晕就断定是停饮，那是不符合经方理论的，你还得再去找其他的停饮证据。就像这个方证里就给你论述了这么多的证。

下边一个症状“脉沉紧”，沉紧的脉（又沉又紧的脉）是一个复合脉象，把它分开，沉脉就是脉体比较低沉，轻取不应，就是说轻轻地摸，摸不到或者不清晰，重按才能找到这个脉，在经方理论里这种脉象常常是候里证，也候停饮，这里肯定就是停饮的指证。紧脉就是指脉体紧张有力，边沿清晰的一种脉。在经方理论它候什么呀？就标志着可能有寒证，或者说疼痛，或者说实证，或者说有水饮。这个地方肯定是水饮了。客观地说，并不是说所有这个方证的患者都表现为沉紧脉，但是条文的作者把这个脉放在这儿，他特意选了这个脉象，一个是这种脉在这个方证当中比较容易出现，比较多见；另外一个它比较能代表这个方证的病理特征，肯定有这层意思。正是因为我们刚才说的，你单个地看每一个方证，它都不具备能够确认方证，单独地看上面这几个方证，包括脉，都不具备单独用来确定苓桂术甘汤证的

特征。但是如果把这些症状集中到一块儿，互相佐证，它就比较清晰了，就形成了特定的一个症状群。但是在临床当中，也不是所有的这些症状在一个人身上都同时表现出来，也不一定，或者说真正同时发现在同一个病人身上的机会也不多。那么这个地方论述就是要我们通过这些证去感悟这个方证的病理。

如果我们进一步去体悟，还会发现另一层的意思。停饮证本身有一个特点，它涉及到全身。比如里证常常的会有消化道的症状，当然说具体的病变位置不一样，有时候也会表现为皮肤病，但是它必须得有里证存在，如果没有，有皮肤病去吃里证的药那也治不了。这个停饮，是人体的各个部位各个器官（恐怕除了像牙齿、骨骼、指甲之类的这些东西）几乎都存在体液代谢的不好。它的特点就在于涉及的部位很多，所以中医里有一句话叫“诸怪病当责有水”，有一些怪病你套什么方证也套不上，好像是什么病都不像，往往都是停饮证。为什么会有这种情况？就是因为它涉及的部位很多，你很难去用一些比较单纯的症状一下把它简单地给描述出来。所以说，停饮症在临床当中实际上也是比较复杂的。形象地说，当你坐诊的时候，问诊快要结束的时候，你开始皱眉头，老觉得不好定方证，这个病人十有八九是水证，恐怕有时候也会夹杂着血证，常常是这样。

“发汗则动经，身为振振摇”，严格地说，不是说的这个方证。也就是说苓桂术甘汤到不了“身为振振摇”的程度，只是头晕而已。实际上是说在这种情况下，如果再发汗会出现什么样的后果。那“身为振振摇”是什么方剂的适应证？是真武汤的阴性证。本来这个人就有停饮的趋势，再误治就会出现阴性证，就是说病情又重了，不是苓桂术甘汤证了，脱离开阳性证的病理了。

我用自己的一个医案来说说辨证过程中常碰到的问题，如果只是看书，难以有这样的体会。有一个病人，主诉就是头晕，我一开始就给的是苓桂术甘汤。为什么？因为没有表实证，身上潮乎乎的，而且

说话声高气粗。后来仔细想了想这跟个人的性格有关，这个人就是那种非常豁达的性格。苓桂术甘汤吃了以后，也轻了，甚至有几天差不多好了，但过两天又不行了。后来我就仔细问了问，他有一些比较特殊的症状：一是小便不利，再一个他每天早饭以后有一阵困。我想这个人的性格是很豁达的，聊天都是很嘹亮的那种，他之所以早饭以后困，就是有点体力不支了，就是说他体能不足。我就按阴证给他真武汤，吃了也有效，但是疗效也不是特别明显。我权衡来权衡去，认为他实际上是阴性证和阳性证的一个错杂，或者说介乎于两者之间，我就把真武汤和苓桂术甘汤合方。其实合方从药上看非常简单，就是真武汤加上桂枝甘草，他吃了以后效果非常好，好长时间没有复发过。

苓桂术甘汤的病理，实际上就是阳性表虚证兼停饮证。这个证看着很复杂，但实际上不是特别复杂。像这类方子可以治疗感冒。如果把病理了解好了，你就知道它应该能治感冒，因为它里边有解表药，你得是这个方证。

我就有这么一个病人，三十多岁的男性，跟我以前很熟，他说这两天感冒了，你给我看看吧。我看他比以前胖了很多，就问他怎么这么胖了？他说前几年脑部做了手术，从那以后慢慢就胖起来了。我就知道这应该是一种不正常的。我问他感冒有什么感觉吗？他说多少有一点发热，然后也没劲，头晕很明显，身上觉得潮乎乎的。当时就写了苓桂术甘汤就四味药，让他去附近药店买。到了第三天，他说你这药还真管用啊，我喝了以后就好了。这个病人主诉感冒带着头晕，从他体态上看，就会想到停饮不是一天了，因为他不是正常的胖，有点浮肿。

另外，我还用苓桂术甘汤治过牙痛。我大前年的时候，好好的就出现牙痛，疼得看书也看不下去，做事也做不下去。我除了牙痛，胃里稍微有一点不舒服，再就是有头晕。一想这不是苓桂术甘汤证吗？苓桂术甘汤能治牙痛吗？但它是这个证，那就该吃。吃下去两个小时

就一点都不痛了。在吃这个药之前的两天，我曾经觉得胃里有点不舒服，我曾经敲胃经敲了一个小时，就是大腿的前侧，牙疼也能缓解了。咱们好多用针灸通过穴位经络来治病的，其实有时候也有效，但是维持时间不长，大概半天的时间，后来又复发了。

这一条做个小结：太阳表实证，经吐、下等攻法治疗后，出现心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧的，为茯苓桂枝白术甘草汤主治之证。此时如果不以本方治疗而误施以汗法的，则可能造成体表组织进一步失养而发生身为振振摇的阴性重症。

我把条文叙述的顺序调整了一下，就比较顺畅。我在写小结的时候，你自己动手的时候才能发现古人的高明，你看古人把“身为振振摇，发汗则动经”放在了苓桂术甘汤主治之前，它本身的意思并不是说这是苓桂术甘汤的症状，但是现在为了把它分开放到后边，放到后边描述上反倒比较困难。我这用了这么多的文字才把它大概说清了，不一定真说清了。

下边是方解。这个方剂是由四味药组成的，茯苓四两、桂枝三两、白术二两、甘草二两，可以把它理解为桂枝甘草汤加茯苓白术，这样方义已经比较好理解了，桂枝甘草汤它的作用就是降气冲、实表，治疗表虚；茯苓白术是去水饮，治疗头晕，这就非常清晰了，没有必要做很复杂的推演。

我在整理这个方证的时候发现一个问题。因为这个方剂是常用的方剂，所以说它治疗的病谱也非常宽，使用这个方剂的人也非常多，统计资料数量也很大，等于说这是一个代表性的方剂。在统计资料中有一大块是对这个方剂的加减，首先大家明了一个事儿，经方的加减，不要轻易加减，一定要在经方理论的指导下去加减。实际上，后世在使用过程中加减情况是很严重的。客观地看，这些加减里边也有一些好的经验，也有不少画蛇添足的东西，资料是连精华带糟粕一块儿统计下来了。

因为这也是个常用方，作为一个例子来讨论一下吧，跟大家说一说呢，会有一个印象，这都是对应着的。之所以它对的病谱那么广，就是因为后世对它进行了大刀阔斧的加减。实际上在网上我们都能看到好多医案，有人说我用苓桂术甘汤治好了什么什么病，但是看看他的方剂，苓桂术甘汤就四味药，他的方剂开了十五六味药，那还叫苓桂术甘汤吗？但是治疗理念恐怕还是不会有大的变化，就是外有表证里有停饮。

下边简单读一下，大家听听有个印象就行了。阳虚甚加附子、干姜、吴茱萸；阴虚者加石斛、麦冬；气血不足者加党参、黄芪、当归、白芍；肝气不舒者加柴胡、川芎、枳壳、陈皮；气滞腹胀者加厚朴、砂仁、木香、大腹皮；胃气上逆者加半夏、生姜、竹茹、代赭石、旋覆花；气滞血瘀者加赤芍、桃仁、丹参；肝阳上亢者加龙骨、牡蛎（像这类的经验都是跟经方理论简直不沾边了，经方里的龙骨牡蛎哪有治肝阳上亢的）、钩藤、菊花；心悸失眠加枣仁、远志；水停胸膈加葶苈子；胸闷气短加瓜蒌、薤白；咳嗽痰多加苏子、白芥子、杏仁、川贝；浮肿者加泽泻、猪苓、车前子、防己、薏米。这个加减的面比较宽，大家就知道一个大概就行了，知道后世用方的加减是非常严重的。

统计它的方证、症状，咱们说得稍微具体一点啊。这个方证总共统计到 418 例，眩晕 180 例，纳呆 153 例，心悸 121 例，形寒肢冷 120 例，呕吐 120 例，胸胁满闷 110 例，胸腹痞满 106 例（后边还有一些症状相对地说出现的几率少一些，跟大家也全面地说一下，因为这个资料比较全），咳嗽 88 例，咳痰 82 例，浮肿 70 例，神疲乏力 70 例，少气懒言 66 例，便溏 58 例，小便不利 56 例，面色不华 55 例，腰背酸痛 42 例，形体消瘦 40 例，失眠 39 例，自汗 37 例，胃部有振水声 37 例，口渴 32 例，气上冲胸 3 例，关节疼痛 31 例，发热 31 例，便秘 29 例。大家注意，这里有一个 58 例的便溏，有一个 29 例的便秘，实际上应该是跟这个方剂的加减有关系。之所以这个方证

概括了这么多的症状，其中有一些绝对不是这四味药能治的。有的就是加减别的方子，或者别的药。我们了解了这些，以后再去看到相关的资料就要客观地看。

舌质：有舌质记录的医案 146 例。淡舌 120 例（淡胖舌，淡红舌，淡舌，暗淡的舌），红舌 22 例（暗红，红绛，尖边红），紫舌 3 例。

舌苔：203 例。白苔 183 例（薄白、白腻、白润、白滑、白厚），黄苔 13 例，黄白相间 6 例，黑滑苔 1 例。

脉象：216 例。弦脉 95 例，沉脉 91 例，细脉 78 例，滑脉 58 例。

现代应用它对的面儿也非常得宽，大家时刻得记着这个事儿，就是这些统计医案里加减的方剂很多。所以说这里边有一些病，单纯用这个方子治，就算有一点点这个方证，恐怕疗效也不会很好，可能按照经方理论应该是还有别的方证。

这些也简单地跟大家再读一下，大家有个印象就可以了。急慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、胃下垂、胃神经功能症、胃潴留、肝硬化腹水、幽门梗阻、急慢性支气管炎、肺炎、肺气肿、肺结核、结核性胸膜炎、气胸、胸腔积液、慢性肾炎、尿毒症、高血压、高血压性心脏病、风湿性心脏病、心肌炎、冠心病、风心病、肺心病、心包积液、心肌劳损、心律失常、心肌梗死、缩窄性心包炎、结核性心包炎、出血性心力衰竭、病态窦房结综合症、肺源性心脏病、难治性肾病综合征、肾小球肾炎、肾结石、癃闭、内耳眩晕、脑震荡、脑炎、脑梗塞、肺性脑病、癫痫、神经性呕吐、美尼尔综合症、百日咳、重症痉咳患儿、婴幼儿腹泻、小儿虚寒性秋季腹泻、小儿水肿、小儿急性肾小球肾炎、小儿肾病综合征、小儿咳嗽、病毒性角膜炎、中心性浆液性视网膜病变、视神经萎缩、中心视网膜炎、羊水过多、特发性水肿、乳腺小叶增生、带下、银屑病。包括了这么多的病，肯定和这个方剂的加减有关，我们很难一一做详细的分析。

胡希恕：68 条这个它是一种什么病？就是简约的说法，这篇文

字搁这块儿就不成立，发汗之后病不解，还反倒恶寒，那么就用芍药甘草附子汤是不对的，这怎么能对呢。他这个书啊，这些地方都不是主要地给你解释太阳病，他略略提一提，可是你自己应该知道，因为头前咱们讲过芍药甘草汤，芍药甘草汤不治脚挛急嘛，芍药有育阴作用，由于津液虚而挛急，同时再恶寒，那么就是芍药甘草附子证。这个附子加到芍药甘草汤里，他说如果发汗丧失体液，而病不好，病要好就不恶寒了，不好反倒恶寒。这个反恶寒，反倒增加其恶寒，以前太阳病的恶寒没有这么厉害，反倒恶寒加甚，那么说明这个病是由阳入阴了，那么现什么证候呢，就这你不能用这个方剂，他总是现四肢拘急，或者腹挛痛，你才用芍药甘草加附子呢，要不然怎么能用这个药啊。

那么仲景他提到这儿，他没详细解释这个证候，因为芍药甘草汤在旁处讲的很多，所以在这里就不那么详细分析，主要目的讲的这个太阳病，太阳病应该发汗，在发汗的过程上，由于发汗不得法呀，由于滥用发汗药啊，或者是他有些宿疾，就是正当发汗，也许他有些什么毛病，就讲这个，这个当大夫也应该知道。所以这个不是主要目的，但是呢我们研究治太阳病，是应该知道的事情，所以他都不够详细。下面也是。

李冠杰：68条这个条文在这一段里应该怎么解读呢？在“发汗病不解”之前就是“伤寒若吐若下后”，如果单纯这么一条的话，应该这么读：“伤寒若吐若下后，发汗不解，反恶寒者”，“伤寒若吐若下后”就是这个条文的第一句话，为什么说是总纲呢？就是说，或者吐了下了以后，发现病不好，再仔细辨辨这不是有表证吗？又用发汗的方法来治疗。这是这个意思啊。那么出现后边这些事儿。这个地方按照经方的原则，如果说是表证，攻了以后表不解，表证仍然存在，应该用桂枝汤来治疗，不能用麻黄汤发汗。“发汗”在经方里有这么一个规矩，一般单纯地说发汗治疗就指的是麻黄汤，这个地方用了麻

黄汤就等于说是一个误治。

“反恶寒者”，它实际上是一个简文。这个地方，前边有病因，后边有方剂，所以这个地方用了一个特别简的方法。如果不用这么简文的方法，条文就会变得很冗长。有方剂在这个地方，因为前边有病因在那儿，两头加到一块，把这些因素都加进去，就会明了这个“反恶寒”强调的是什麼。这个表证不愈，本来就应该恶寒，这儿又来了一个“反恶寒”，实际上就在于什麼呀？如果单纯地计算数量的话，这也是三种误治了，应该是吐、下，当然我们不能这么机械的解读啊，就是说经过了吐或者下，这也可以吧，但是反复误治这是肯定的。经过反复误治以后，这儿的恶寒指的是已经陷于阴证表现出来一味恶寒的那种情况，甚至都有点四肢厥冷的倾向。

从治疗方剂这一层来看，在恶寒较甚的同时，还可能存在芍药甘草汤证所有的证候，这样条文就丰满起来了，这儿强调恶寒实际上是病重了，陷于阴证了。再看方剂是芍药甘草附子汤，附子有附子的作用，芍药甘草汤应该有芍药甘草汤证。

“虚故也”是旁注文字，纯属多余。为什么加上？你稍微往后一看就明白了，第 70 条“发汗后，恶寒者虚故也”，条文里已经说得清清楚楚了，再在这个地方加上这个，不能说你错，但是有什麼用处吗？就在一行后边就是这句话，从这个地方细究的话，能看出这三个字的注解者水平真得不高，太肤浅了。

“芍药甘草附子汤主之”在这儿就不仅仅是治疗方剂的问题了，同时也是用来界定条文里论述的症状范畴的作用。就是在芍药甘草汤的基础上，又见恶寒特别甚，就这么个意思。要很好地认识这个方证，就不能不去参照芍药甘草汤证，因为这儿例举的症状非常少。但是，芍药甘草汤证我们在学习第 29、30 条的时候有，那个地方论述的也非常简，就论述了一个“脚挛急”，也没有很多的证，而且在《伤寒论》里芍药甘草汤就只有这两处。我们再回顾一下芍药甘草汤证临床

统计资料，这就仅仅跟大家说症状，其他的就不说了，芍药甘草附子汤治的症状有：四肢厥冷、脘腹冷痛、眩晕、面色苍白、倦怠乏力、腹泻、呕吐、喘促、少气懒言、纳呆食少、咳嗽、遗尿、恶心、咳痰稀而白呈泡沫状、衄血、吐血、便血等。这些症状我们也得客观地看，芍药甘草汤特别是在后世使用过程中，不进行加减的不多，加减得很多，所以症状表现得比较复杂一些。芍药甘草附子汤所治的病谱也非常宽，有兴趣的可以查查资料去看一看，这儿就不详细地说了。

那么这一条所论述的病理呢，就是阴性里虚血虚证。看看这个方药的组成是芍药、甘草各三两，炮附子一枚。从方剂的组成来看，寒热倾向不是很明显，所以在病理里边没有涉及到寒热。

因为这个条文非常的简，咱们有必要对芍药甘草附子汤证进行一下简单的分析。这个方证本身就是芍药甘草汤证陷于阴证，病理上就是这么一个病理状态。条文里虽然说是表证经过误治以后发生的症状，但是出现这个方证，就已经由于误治太过，或者说人体本来就不是挺壮，经过一再的误治，这个病已经不是在表证的病理阶段了。从论述上我们能够看出来，病已经脱离开表证的病理阶段了，陷入了机能沉衰的阴证，所以条文里用了“病不解”，没有用“表不解”。要是按照条文的论述来看，表证经过了误下、误吐，本来已经虚了里了，如果说再用发汗的方法，古人举它为例，它就容易出现这个方证。本身里虚，人体的能量来源就少了、不足了，这个时候再发汗损失体表的水分，里边能量供应不足，外边再进一步攻表损失水分，这时候就会出现脚挛急，或者肌肉疼痛等等这一类的症状，就是因为营养跟不上了。芍药治的就是肌肉组织、血液里供给的某种营养成分偏少、不足，芍药可以改善这种营养的供应。这个方证在这儿出现也是非常自然的过程。

临床当中，经过一再误治发生这个方证的机会很少，恐怕以后我们很少看到这样的病理过程了。那么，我们在临床当中应用这个方剂，

就是把握芍药甘草汤证就行了，芍药甘草汤证陷于阴证。

我有一个医案。一个 70 多岁的老太太，她儿子开了一个公司，有钱，老带着她到市里找一个中医看病吃药，吃了药身体慢慢也在好转。但是有段时间就发作两条腿抽筋，那个医生治不了，老吃药也不好。后来找到我，我就问问她的情况，年龄在这儿，有时精神不好，两条腿有活动不便，再加上抽筋抽得厉害，给她芍药甘草附子汤，三天的量。吃完以后就找我来说：你这个方子一天吃这点药，吃了两天就好了。我叫她把药全吃了，后来她说：我找到那个医生，把他好损了一顿。说人家吃这点药就能治了病，你怎么天天吃药熬那么长时间就治不了呢？实际上，如果不用经方，对这个病理理解的角度不一样。

做个小结：太阳表证经吐下后，见表不解，又施以汗法，结果使病情加重，如果表现为恶寒明显，并有芍药甘草汤证症状反应者，为芍药甘草附子汤主治之证。这小结呢用的文字比较多一些，把这简文写的比较明白一些。

下边是方解，方剂由三味药组成就不说了，方药也非常简单，方义就是芍药甘草汤证陷于阴证。就是芍药甘草汤证又出现了机能沉衰的情况，所以说加上附子，也非常简单，没必要去做过多的解释。

需要跟大家说的是，《康平本》里没有芍药甘草汤这个方剂，条文里论述有，恐怕是遗漏了。条文里有芍药甘草附子汤这个方剂，有这个方剂也等于说为芍药甘草汤起到了一个佐证的作用。这儿呢是芍药、甘草各三两，附子一枚，把附子去掉就是芍药甘草汤了。《宋本》里芍药甘草是各四两，这也符合古人用药的习惯，药味减少以后，药量会适当地增加。比如柴胡桂枝汤，相当于小柴胡汤和桂枝汤的合方，但是药量基本上都减了一半。

咱们这儿说方证，是专门统计的芍药甘草附子汤方证。统计到的医案一共几个，方证和现代病都非常简单，甚至连舌象、舌苔记载都没有。这个方证的症状：表现为多汗、恶寒、肢挛急，就这三个症状，

但非常贴切。

脉象：沉细或者微细，也非常准确，特别符合这个病理特征。

现代应用里的病名：一个是腓肠肌痉挛，一个是腰冷痛，其他的都没做统计，没做记载。

实际上这还有一个问题，因为条文里论述的非常简单，再加上《宋本》把它跟前边的一条分开了，所以说造成后世对这个方剂的理解上存在不到位的地方，在应用中也非常少。实际上，在临床中只要见到芍药甘草汤证有些机能沉衰的情况，就可以用，应用的机会是比较多的。

胡希恕：69条，这都不象话，他说这个发汗，或者又下，这病还不好，如果烦躁者就用茯苓四逆汤吗？这也不对。这个茯苓四逆汤，这个人参，就是胃虚，津液虚。就是四逆汤证有人参证，就是四逆汤证心下痞硬嘛，同时烦躁，这个茯苓治烦是肯定的，治烦治心跳。那么张仲景也没这么说明，总而言之他是发汗，若下之，这人虚极入阴了，而这个烦躁跟上边那个干姜附子汤的烦躁是一样的，阴证的烦躁，那茯苓四逆汤你得分析了，那么在霍乱篇有这么一节，他说恶寒脉微而复利，利止亡血也，人参四逆汤主之。那么这句话什么意思呢？他本来讲的是霍乱呀，霍乱是上吐下泻，耗损人的津液是最厉害了，损津液就损血液。那么后来这个人就是虽然不泻利了，脉微，恶寒得厉害，说这个病没好啊，不吐不下了，可是脉微而恶寒，而又复利了。霍乱好了，现在又下利了，完了再补充说了，利止，说是呀霍乱这个利止，那不是真好，那是亡血也，现在的话就是脱水，他没有可吐可下的了，所以他当时利止，但是病没好，所以脉微恶寒，霍乱篇里要详细讲的。那么这个呢是亡血了，我们方才讲了，这种亡血就不能用生地了，它是阴寒呐，恶寒脉微而复利，以前霍乱这个利止呀，那就是无可利而利止了，那就是没有什么可利，当时是止住了，可是这个病没好，所以脉也极微，脉微者亡阳也。这个亡阳指着津液。那么现

在又利了，那就是这个病不但有阴寒，而且阴血也虚到家了，所以这个地方你要想法滋阴，滋津液，益血液，只能健胃，他这不是阴寒证嘛，在四逆汤的基础上只是能加人参，那生地、麦冬简直就是不行啊。

所以这个地方就拿《医宗金鉴》，《医宗金鉴》是太医院那些吃俸禄的人，他们也瞎闹啊，他们说这不对，他们说附子、干姜为大热药，亡血怎么能吃这个东西呢。其实他是不明白，这个亡血要看怎么一个证候，他是阴寒的证候的血少，你吃寒性的滋阴药啊，那还不让他死呀，所以就拿《医宗金鉴》也这么说，那正是阴寒的津液虚血液虚，同时还得治阴寒不可，回阳啊，还得用四逆汤的基础，那么血液哪来呢，即健胃，他胃气不复嘛，胃气一复，水谷之气一行，血液马上就恢复了，所以他是用四逆汤加人参汤，治阴寒而血如注，他用这个方子。咱们这个呢又加上茯苓了，那么在这个人参四逆汤证又加上一个烦躁心悸这类的情况，你只是用人参四逆汤不够了，还得加茯苓。茯苓这个药啊，睡觉安眠都用茯苓啊，它治悸烦，心跳，烦，它同茯神差不多。应该有这些问题，那么他这个书也没明说。他没明说这个道理，就是四逆汤，你们看去，四逆加人参，后头也有，那么茯苓，这一段都讲茯苓呢，都讲这个利尿药呢，他就不明说，这个与一般的四逆汤证的不同点就是烦躁。那照着本文说呢这两段都要不得，一个病，发汗不好，恶寒，那你就给吃芍药甘草附子汤，这也不行。这一段也是一样，发汗，若下之，若烦躁就给吃茯苓四逆汤，也不行。所以他这个内容啊不这么简单，文字是一个简文，可这个非知道不可，要不然的话，我们遇到这个病就根据这个，照这条文来用就错了。

李冠杰：69条跟68是相同性质的问题，也必须跟前边的“伤寒若吐若下后”联系起来。等于条文前边再加上那句话：“伤寒若吐若下后，发汗若下之，病仍不解烦躁者”，这样相对就比较清晰了。

“发汗若下之”肯定是一个误治了。若吐若下后，再发汗或者说下之，或者说发完汗再下之，都不正确，都属于误治。本来应该是

一个桂枝汤证，这样一再误治，或者用了麻黄汤，或者用了承气汤，看着表不解，表不解以后经过吐、下了，看着还有表证，然后再发汗，发完汗以后看着肚子里又腹满，再下一下吧，比如小承气汤再吃一下。这就一再的误治，必然会造成里虚的重症。

这个地方也用了“病仍不解”，非常有分寸，用的也是一个“病”字，而没有用“表”字。这个时候已经不可能存在表证了，人体屡经误治，正气已经很微弱了，不可能再有表证了，所以说“病不解”。

“烦躁”不是阳性证的烦躁，而是人体虚极了，已经濒临于虚脱表现出来的一种烦躁，实际上是一个比较危险的证候。虽然条文里仅仅列举了一个症状反应，就说了一个“烦躁”，但是这一条也得前后对照着看，这个病因比别的要重，这是吐、下了以后，再发汗又下，或者说下了以后又下，对人体的伤害就比较重了。前边有病因，后边有方剂，就可以知道了这是一个比较重的病了。古人之所以把病因放到前边，就是既客观又省了很多事。

这个病理就是阴性的里虚寒证，同时有津液虚又有停饮这么一个错杂的症状。这种错杂的症状，在这种重症的情况下，因为人整体的协调性都已陷入沉衰，已经不是一个比较正常的人体协调那种情况了。下边在分析方剂的时候，结合着方剂再对这个病理再进一步地看一看。

做个小结：太阳表证经吐下误治后，见病不解，再施以发汗或是泻下的方法，一再误治，致使疾病进一步加重，患者因虚极而发作烦躁，并表现为阴性里虚寒证的证候，为茯苓四逆汤主治之证。

这个方剂由五味药组成：茯苓四两，人参一两，附子一枚（生用），甘草二两，干姜一两。《宋本》里干姜是一两半，是不是《康平本》里掉了一个“半”字？我们现在不得而知，应该说这个一两半应该是对的。

这个方剂可以理解成在四逆加人参汤的基础上再加茯苓。把四逆加人参汤搞清楚了，这个方剂的方义就非常清楚了。四逆加人参汤治的是什么病？它治的是阴性里虚寒证加上津液虚损的重症，原文出在第 385 条：“吐利恶寒，脉微而复利，四逆加人参汤主之”，条文也非常简，实际上论述的是一种什么病呢？就是得了下利这种病以后，陷于阴证见恶寒（实际上这个恶寒也是四肢厥逆），下利止了之后但病并没有好。因为什么而止呢？就是下利太严重了，没有东西可下了，脉象很微弱，但是不久又出现了下利。再出现下利，说明利止不是病好，不下利是因为肚子里没有东西了，病并没有好。所以用四逆加人参汤一方面救逆，一方面补虚。

茯苓四逆汤就是在四逆加人参汤基础上加上茯苓。如果再看看条文就很容易理解这个方义了，经过了吐下，经过了这么多的误治，而且他最后强调什么？其他的方证里都是后来又发汗，或者说如果发汗会怎么样，就这一条里边又多了一个“下”，又下了，本来人已经虚了，再去泻下就会造成人体更虚，又吐，又反复地下，再加上发汗，人体的津液就损失得非常厉害。里虚不但造成津液供应不足，也会造成机能不足，机能不足也会造成体液代谢不好，废水不能畅通地排出去。加上茯苓不是一方面的作用了，一是可以治疗烦躁，它有安神的作用；另一方面还有利尿的作用，就是改善体液代谢方面的作用。

下边看看方证，总共统计到了 29 例。在 29 例当中，症状表现为发热 15 例，烦躁 15 例，四肢厥逆 15 例，畏寒 9 例，失眠 6 例，头痛 6 例，短气 5 例，面色晄白 5 例，腹泻 5 例。后边还有一些症状出现率很低：大汗、形体消瘦、胸胁闷痛、腰痛、尿少（大家看看，这个尿少其实既有津液虚的问题，也有体液代谢不好的问题）、神疲倦卧、浮肿、腹痛。

舌象：舌淡、舌胖大有齿痕（这里也佐证有停饮证）、舌红、舌淡润。

舌苔：薄白、无苔、微黄而腻、白苔、黑苔、苔黄燥。

脉象：脉象相对说比较复杂，有数脉、细脉、沉脉、微脉、洪脉、弦脉、紧脉，另外呢还有伏脉、浮脉、缓脉、迟脉、涩脉，这几种脉象都有出现的。

它对应的现代病：肠麻痹、感冒、慢性肾炎、泌尿系结石、风心病或肺心病引起的心力衰竭、冠心病、急慢性胃炎、慢性胃肠炎、震颤性麻痹、心力衰竭、肝昏迷、肾功能衰竭、休克、心肌梗塞。

胡希恕：70 条，这个在这一点就看明白了，他讲这个发汗能造成虚寒的这种情况，头前讲的都是，这是由于虚，虚达到一个相当程度就转入阴，转入阴寒证。“不恶寒，但热者”，一点也不恶寒，但热，就是反恶热，这是实，实指着胃家实那个实。虽然这个发汗，能得到两种问题，一个由于虚极而入阴证，上边讲了，另一个由于丧失津液，胃中干，那就能转阳明病，这个底下要讲这个。所以主要讲的就是为这个，所以这个发汗不可等闲视之，要是不得法，造成这个疾病相当地多，上边这个虚寒的这种，底下还能够转成实热证。实热怎么治呢？就是调和胃气了，可以与这个调胃承气汤，这也是一个概要的说法，所以搁个“与”，不说“主之”。那么但热者，实也，也有白虎汤证，热结于里，也是但热不寒呐。也有调胃承气汤，真正实了，有潮热，可以用调胃承气汤，要说大实呢，当然还得用小承气汤、大承气汤。他这个意思呀不是在太阳病、太阳篇里头，专讲这个调胃承气汤，不是，和上边这个芍药甘草附子汤、茯苓四逆汤一样，不是专为讲这个，因为我们讲太阳病依法要发汗，但是发汗你得守规律，该用哪种发汗药用哪种发汗药，而且就是该这么用，也常常地发汗之后，由于他平素身体的关系，也兴许有这个那个的后遗症发生了，也有这种情况，也得知道啊。要是错了，错了更不行，错了不为虚，就为实，这个虚寒上面举两个例子，芍药甘草加附子、茯苓四逆汤就是。那么实呢，也举一个例子，调胃承气汤就是，和胃气，他是这个意思。主

要的意思还是讲太阳病为主，那么调胃承气汤不能说是这样子，不恶寒但热就使调胃承气汤也不对的，因为后头还要讲的，咱们到阳明篇的时候就要详细讲了。这个发汗，根据头前那一条啊，汗、吐、下，要是用之不当，也属于亡血液亡津液，那么这个结果呢？由于这个津血虚极，必转为阴寒虚证，所以他要怕冷，头前讲这个就是了，“发汗病不解，反恶寒者，虚故也。芍药甘草附子汤主之”，和那一条也是，69，“发汗，若下之，病仍不解，烦躁者，茯苓四逆汤主之”，这全是由于发汗，亡失体液，体液亡失一个相当程度，转为阴虚证，所以恶寒。那么也有呢津液丧失太多了，胃中干，转成为里实证，就是阳实证了，那么这个就是不恶寒但恶热，“不寒但热者，实也”，我们后头讲阳明篇就知道了，这是胃家实这个实呀，就变成阳明病了。那个虚寒呐就是属于太阴病的范畴，这个书上没明说，意思就是这个意思。那么转向实证怎么办呢？虚证头前都有了，当和胃气，那就得调理胃。调理胃的方法也很多呀，那么他也是举一个例子而已，“与调胃承气汤”。那么只是不恶寒但热，也不应该用调胃承气汤，所以他说“与”，不搁个“主之”，这就是明证了，还要加以细审啊，当然一般是用调胃承气汤的机会多，所以他说个“与调胃承气汤”，可以与调胃承气汤的机会，那么在什么情况之下呢？我们后头是有的，在这都没明说。那么在这个书上呢，在《玉函经》上说是小承气汤，一样，小承气汤是以胀满为主，大黄、枳实、厚朴配伍到一起的，但是它去热的力量差，没有芒硝啊，这个调胃承气汤啊偏于去热，对这个胀满作用不大，没有厚朴、枳实。这也就是说我们根据其他的证候，有用小承气汤的机会，当然也有用调胃承气汤的机会，他说个“与调胃承气汤”，就让人啊临证细审的意思，不一定得用它，那么一般说呢可以有用的机会，因为我们上次讲过，他不是专为调胃承气汤立论的，他讲的是太阳病，那么太阳病依法当发汗，但是发汗不合法，可以转为虚证，也可以转为实证，主要的意思在这一点。实证就要攻实

呀，所以调胃承气汤是攻实之法。那么这个方剂呀就是芒硝、甘草、大黄这三味药，这是一个泻下，它叫调胃承气汤，就是调和胃气呀，其实这个药呢泻下力量很重，这个大黄与芒硝合用，根据药物配伍的关系呀，这个大黄能加强肠子的蠕动，肠子蠕动就使着大便往下走。这个芒硝能稀薄大便，尽是干便，怎么蠕动也不下去，再配合芒硝，咸能软坚嘛，能稀薄大便，使之稀，那么加上大黄这个蠕动就了不得了，大黄配合芒硝啊，古人有句话，说是大黄没有芒硝，就像快刀不开刃一样，它这个攻破的力量还是差的，所以搁一起呢泻下比较重。但是里面配伍大量的甘草，这个甘草啊，在病情上缓急迫，可是它也缓弱药力，所以调胃承气汤用甘草的关系，甘草这味药啊你象我们用泻下药啊，有甘草不会有虚弱的情形，所以甘草这味药也能缓和药力，所以叫调胃承气汤。大小承气汤里都没甘草，那就是急攻。那么这个药啊就是里实证，大便不通，发潮热，这个芒硝同石膏的寒性差不多，但是石膏没有泻下作用，这个芒硝有泻下作用，这个药是咸寒的药，解热的作用相当强。也就是说里实证，发潮热，热得厉害，大便不通，可以用调胃承气汤调和其胃气。

李冠杰：70 条应该跟条文前的“伤寒若吐若下后”结合起来，也就是说“伤寒若吐若下后”出现的这些情况，就应该用这个方剂来治。

我们解读一下：

“发汗后恶寒者，虚故也”，在这儿应该有多层的意思，一方面总结上面的各个方证所出现的例子，上面出现三个方证都是虚证的例子；一方面承启下边出现的方证，言外之意就是说它是另外类型的，虽然也是近于这样的误治，但是有可能出现实证。

“恶寒”的机理实际上就是人体的机能不足，主观上就感觉冷。

“虚故也”就明确地提出了一个很重要的病理要素，同时在经方里也是一个很重要的辨证要素。现在把它总结成病理辨证，虚和实也

是很重要的疾病性质，一种界定。这个“虚”怎么去理解呢？我找了一段《中医辞海》上的文字，这是比较权威的诠释，跟大家读一下，虚：综合代表各种正气不足，正气虚损为矛盾主导方面的病理变化。正气不足标志着机体气血、津液、精气和脏腑、经络生理机能低下，营养供应不足，抗病能力较弱。在临床上则表现为一系列虚弱、衰退，机能下降，营养不足，病程缠绵消耗性疾病。这是对“虚”病理概念的诠释，还是比较切合实际的，跟经方理论能够接轨。虚和实是一对对应的病理概念。实际上在经方里“虚”说的是人虚，“实”指的是病实，而不是说人出现有余的情况。

下面“不恶寒但热者，实也”，“不恶寒”就是说它指的是发汗以后而言，也就是说发汗以后恶寒的，以前不是表证吗？表证就应该恶寒，经过发汗以后“恶寒”的症状反到消失了，说明表证已经解除了，或者准确地说已经脱离了表证的病理阶段，已经没有表证了。

“但热”一个是指的发热；一个指的是恶热，但热就是只是热，包括这两个方面。由于病情经过误治以后恶化了，这个恶化向另一个倾向，跟前面列举的方证是相反的倾向，它是偏于亢奋产生了里热，人体这个时候就会出现体温升高，有里热也会出现体温升高的情况。再一个因为里热严重，患者不但不再恶寒了，反而转为一味的恶热。这实际是里热对人体神经系统的刺激造成的。

“实也”就是说的实证，是虚证的一个反面，与虚证是对应的。但是“实”在《中医辞海》中找不到它的解释。我们根据经方的理论，这个实证是指的哪一类的情况呢？就是人体表现出病态的机能方面的亢奋和某些误治的积滞。它实际上是疾病表现为一种实证的证候，这是我对实证的理解。

这个条文它所论述的是太阳表实证，经过误吐误下以后又发汗，人体出现了一种与前面不同的病理情况，它产生里热了。产生里热也应该有条件的，一是这个方证的人，应该比前面出现那几个方证的人

体质上可能要好一些；误治的方法恐怕对人体的伤害也没有那么重。反倒是导致人体出现这么一种亢奋的状态。

对于这种状态的治疗，条文里列举了一个调胃承气汤，作为一个范例。并且语言用得也非常有分寸，用了“与调胃承气汤”，而没有用主之。它的意思就是在临床中视具体情况，看它是什么方证，就用什么方子。但是方向上一旦出现里实热证，方向上就是承气汤之类的方剂，像大小承气汤都有应用的机会，具体要看方证了。

这一条的病理就是里实热证，非常简单。

做一个小节：太阳表实证经吐、下误治以后，见病不解，有误施以发汗的方法，如果出现恶寒更甚的，说明人体陷于虚证；那么如果不再恶寒反而出现恶热和身热的，则为实热证，应该根据具体的疾病反应症状，与调胃承气汤类方剂来治疗。

关于调胃承气汤，在学习第 29、30 条的时候都已经解释过了，在这里就不再去重复了。

到这儿四条就全部学完了，但不能就这样了结了，我们还得回头来再看看，这几条把它并为一条学习，跟《宋本》里分成四条学习有什么不同？我们去查一些相关资料，凡是有争议的、有出入的这些条文，我都会查阅一些相关资料，纵观历代对于 68 条、69 条、70 条的解释，你会发现几乎所有的注家，没有一个能跟这一段条文前面的“伤寒若吐若下后”结合起来解读的，像这种解读方法，它没有准确地把它解读好的可能，所以很难理解到经方理论的真谛。大家有机会看的时候你可以注意一下，你就会发现理解得五花八门，什么样的都有，但就是不能切中要害。同样是没有看到《康平本》，如果再去温习一下胡希恕先生对这些条文的解读，你会发现他的解读在所有后世注家里是最贴近原本文本的。我们从这一点上看，也不能是单纯地去强调某一个侧面，就是从某种意义上说，从认真的程度上说就是被误导了。误导了以后出不来，理解不到经方的真谛所在。

我们把这四条通读以后，不难发现这个条文实际上是以这个太阳表实证为例子，它总结了临床中常见的太阳表实证被屡用误治的办法，而容易出现的几种较为典型的病理状态，就是容易出现的几种方证，把它放到一块。从这里边把它联系起来，你会体悟到很多，都是当做例子来说的，而且同时给出了具体的治疗方法。这些治疗方法如果再一换角度，没有病因，就是没经过误治，如果是这个方证的话，也得用这个方证来治。这一下宽泛了很多。没有这个病因，人为什么会出现这个情况？那么人肯定会，或者是机能过于沉衰了，人太虚了，或者是人有停饮了等等的吧！总是有这方面的原因的。

下面我们把这四条通起来做一个小结，这个小结我想是这样，因为前边每一个都做了小结了，我们只做一个跟帽子一样，重新给它带一个帽子，大家看看这样去理解，把下面几条再罗列上，是不是就比较恰当了：太阳表证如果误施以或吐或下的方法治疗，常出现“表”不得解，反伤其“里”的不良后果。如果此时见病不解，再施以攻法，将会使病情进一步复杂化，而发生多种变证。下面列举几个常见的例子，就是我们学习的下边这几条。我们前面学习的小结再补充到下面，这样整个这个条文就变得比较完整了。

关键是它们之间本来论述的是一段互相之间有内在联系的，而且形式也有联系的。断开了以后，反倒对这个条文内在的东西全都给抹掉了，非常不好。咱们为什么叫“返璞归真学经方”呢？就是我们最大限度地恢复到经方理论的原貌，用我们今天及前人所有积累的一些知识，取其精华，去其糟粕，我们再去认认真真地学一遍经方。这样大家可能注意到了，我们在学习经方的过程当中，比较强调于对理论和病理理解。你只有在这个层面上掌握得好了，你才能在临床中应用得活、应用得好、应用得准确。

大阳病、发汗后、大汗出、胃中干、燥烦不得眠、欲得饮水者、少少与饮之、令胃气和则愈、若脉浮、小便不利、微热消渴者、五苓散主之、（71）

胡希恕：那么这一条前一半是承接上一条说的，说太阳病当然可以发汗了，如果发汗不合法，造成大汗出。这个发汗，头前讲了，不要大汗，这与护理也有关系，你不那么大捂大盖，不会出大汗的。要非法，指着大汗出，身上水分丧失太多了，那么这胃中水分也被夺，外面舍水分，胃里头水分也被夺，所以胃中也就是干了。干了，他想喝水，而且胃中干，胃气就不和，烦躁不得眠。那么这个时候啊没有其他的病，也没有大便干等等这些情况，也不谵语烦乱，光是人烦躁而渴，这个时候可以“少少与饮之”，他就是胃缺水。“少少与饮之”这是个重点，不要大，这个胃中干就是人想水喝，你要不限制他，他猛喝，就坏了，那人非喘不可，因为渴得厉害，喝的水存到胃里头，压迫横膈膜就要喘的。那么少少给他，一点一点给他，胃得了滋润了，胃气和，不但不渴了，他也不烦躁了。这个我们在临床上也常遭遇的，那么发汗后，汗出多了，病是好了，但是呢由于胃中干，他有这么一种反应，人是烦躁不得眠，渴欲饮水。那么这个时候不必给他吃药，少少给他水，胃气和就好了，这是一个。那么底下这一节呢，与这个就不一样了。底下这一节就是误发里有停水人的汗，这根据头前啊，头前不有麻桂枝去芍药加茯苓白术汤，觉着小便不利，水不下行，里有停水，这个发汗表不解，非得利小便不可。那么就即便发汗汗出而脉仍浮，“脉若浮，小便不利”，他原来就有小便不利了。“微热消渴者”，这个表不解，还有微热。消渴就是随饮随渴，叫做消渴。那么这种渴就与上边不一样了，上面那个渴，喝点水就好了，这个不对。要是小便不利，脉浮微热这种渴，这是由于小便不利，里有停水。那么里有停水怎么渴呢？里有停水一般都不渴，比如胃有停水，人都不渴，唯独这个由于小便不利而里有停水，非渴不可。这个也很好理解，

由于小便不利，我们身上这个废水呀，应该排出的水而不得排出，那么你再喝水呀也没法吸收，你比如我们静脉里头充斥一种废水，分解到肾脏，到小便那排不出去，那么达到一个饱和量，你再喝水也不吸收，没法吸收了。可是组织上缺少水的营养，他渴，反应到人的食欲上面就渴。这种渴相当地凶，它叫消渴呀，你怎么喝，这水还在胃肠里头，它不吸收，而这个组织还是需要水，所以渴得相当厉害。这五苓散的渴是两个内因，这是一个，由于小便不利。另一个就是热不除，有热，那么各组织细胞又缺少水的营养，他渴，同时有热，他烦渴。这两个加到一起了，所以形成这个微热消渴，这是五苓散证。我们用五苓散一方面是解表，利水解表，那么就逐其热了。那么同时通利小便，就是包括水代谢机能整个恢复了，旧的去掉了，新水自然也就吸收了，他就不渴了。在后面注的有几句话，“即猪苓散”，这个是错的。猪苓散在《金匱要略》上有，猪苓、茯苓、术这三味药，就是白术了，这个叫猪苓散。大概也解渴，但不是五苓散。这后头五个字大概是注错了，“即猪苓散是”这错了。你们回头找一找《金匱要略呕吐下利》那一篇里头有猪苓散，是呕吐而渴者，吃猪苓散。他渴想水喝，水停这个地方还是吐，这个恶性循环。那么这个怎么办呢？这个猪苓散利小便，还解渴。他要是不渴，里头也不停水了，这个里头也不能再有了，你们看看《金匱要略·呕吐下利篇》。那么这一节后头注的这五个字是错的。这个五苓散啊，茯苓、猪苓、泽泻、白术，这都是利尿药，而伍以桂枝，配伍桂枝，小量，你看桂枝才搁半两啊。那么这个方剂，桂枝也治气上冲，桂枝汤里是主药了，它也解表，解表去热。我们这个小便不利呀，常由于气上冲，所以利尿药都搁桂枝的多，搁桂枝呢镇其气上冲，不让气往上来，气凌于上，往往诱导水往上不往下。那么另外藉利尿药的群力，达到小便行于下，利尿。这个在利尿药里是相当重的一个方子。那么这几味药虽然都是利尿药，在临床上应用是不相同的。猪苓这个药利尿的作用相当强，同时这个药

利尿之中还解渴，它是寒性利尿药，你们看是利尿要是渴的话，都有猪苓。这个泽泻是甘寒的药，也是寒性利尿药，甘寒，它入胃，所以胃有停饮（就用它），这个白术也入胃，白术偏于温，这个泽泻偏于寒，那么假设胃有停水，又不是那么寒，而且反而有热，用泽泻。这个泽泻，凡是胃有水，都是致头晕，泽泻、白术，这个药都治头晕，所以也是个利尿药，它还治头晕。在临床上，由于里头有停饮而头晕，那么我们用一样利尿药，小便不利，有头晕，白术、泽泻这药我常用。这个茯苓呢咱们讲过了，这个茯苓治心悸，心悸、心烦，象肉跳，这都是用茯苓，它也利尿，它也入胃。茯苓啊性最平和，所以一般利尿药常用它，尤其咱们现在说神经官能症，关于神经方面的，由于停水造成的多用茯苓，你看安眠药，酸枣仁汤也是大量用茯苓，你不搁茯苓都不行的，它对神经官能这方面的病最多，尤其心悸、心跳，不但心悸、心跳，其他地方跳，它也治。所以这几个药啊，共同的作用是利尿，特殊的作用并不一样，就像方才我说的那个。所以五苓散，少加桂枝，既能解热，又能利尿，又解渴，当然也治头晕了。这个利尿药里种类用的比较全。我们现在用面儿药的也有，不过常常用汤药。我们用汤药，一般说来，头前这四味药都可以用 9 克，桂枝可以用 6 克。但是这个水逆，饮水则吐，叫水逆，后头有。这个还是用面儿药好，汤药不大适宜，这是通过临床上的观察得出的结论。现在我们常用汤药，这个分量大致可以这样，头前的各 9 克，桂枝搁 6 克。五苓散方猪苓十八铢（去皮）泽泻一两六铢白术十八铢茯苓十八铢桂枝半两（去皮）上五味，捣为散，以白饮和服方寸匕，日三服。多饮暖水，汗出愈。如法将息。

李冠杰：这条在《康平本》里是顶格排版的条文。

但这里边有一个词在《康平本》是“燥烦不得眠”，在《宋本》里是“烦躁不得眠”，应该是有一点区别，在解读的过程中我们再作一个简单的分析吧。

下边解读一下：

前边“太阳病、发汗后、大汗出”，这个是以病因的形式来论述五苓散方证的病理基础。当然它里边有一个纯属表证，解了表以后，因为发汗太多出现“胃中干”的情况。这是两种情况，但是它们出自近似的病因。比如在临床中有个人感冒了，然后让他吃发汗药，汗发得太多出现津液虚损得厉害，一些津液虚的症状出来了；或者说它是新加汤证；或者说它是表解了以后但有点不舒服；有的是因为本身就有停饮，吃了发汗药以后汗发得太多，停饮证更厉害了，这就是五苓散证的由来。在临床当中可能是完全一样的情况吗？就算都是发汗多，发汗程度都一样吗？不一样的。所以，这个地方它是借助于病因来论述病理基础，有病因在，大家就知道像这一类的治疗有可能造成人体津液虚，也有可能加重人体的体液代谢不好的情况，这一条就是论述的这样的情况。

“太阳病”在这儿指的就是整个的太阳病，我们就可以笼统地把它认识既包括表虚证，也包括表实证。它具体的论述了发汗太过——“太阳病、发汗后、大汗出”。说的已经非常得明确，就是发汗太多了。要如果仔细推敲，太过其实也会有很多原因，如果有临床基础，你理解这个就会想到很多，吃了发汗药以后出汗太多，实际上这里边还有其它的因素，假设桂枝麻黄各半汤证，服了麻黄汤就有可能出汗太多；如果桂枝汤证服了麻黄汤，那就更了不得，就算是麻黄汤证，用了麻黄汤如果护理不当也有可能出汗过多。如果没有临床基础，跟临床实践联系不起来，那你就会想到是太阳病发汗后（大汗出嘛）汗出得太多了。为什么发汗太多呢？可能觉得反正论述就是这样，也许找不到一个很明确的认识。实际上要是把经方的这些东西跟临床结合在一块，都是活的，没有什么东西是特别的、一点变化的余地都没有，不是那样。

这条就是论述了发汗太过以后，出现的两种情况：第一种情况基

本上就是方与证基本相应，我们具体把它想象成麻黄汤证喝了麻黄汤，但因为护理不当，出汗出得太多了。出汗太多了以后出现什么情况？它先给你作了一个病理的解释——胃中干，因为汗液出得太多，造成人体津液虚损，就是胃中缺水了。那么胃中干的反应是什么呢？

“燥烦不得眠”，《宋本》里边就给它改了，把“燥烦”两个字颠倒了一下，这个“燥”字成了“足”字旁的“躁”字，标准的烦躁的“躁”字。我们今天看到的是这个样子，就只能这样分析，是不是在抄写的过程中会有手误？现在已经不得而知了。现在有一个问题，这两个版本的一字之差和位置的颠倒，是有一定差别的。这儿本身论述的是什么？津液虚损的厉害，胃中都达到胃中干的程度了。这个时候人要如果说陷于烦躁的话，后边有“不得眠”——不能睡觉，就是影响到不能进行正常的睡眠，这个“烦躁”就带有某种枯燥的感觉，缺乏水分嘛，他口渴，因为汗出的也太多了。实际上在临床中我们碰到这种情况的机会不是很多，但是出汗多了以后，人特别得疲乏的情况是很多的。这个说的是表证已经解了，由于发汗发得太多，在短时间内人体处于一种全身性的津液虚损的状态，从胃里吸收的水分短时间内满足不了整体的需要，就出现了暂时性的体液的缺乏。所以说像这种情况也是实践经验来的，如果说人真处在这种情况下，他就会感觉到非常的烦躁，甚至都影响到睡眠。

这个“不得眠”里边还有另外一个因素，后边它有这么一句话“令胃气和则愈”，言外之意现在胃气不和了。但是“胃气不和”在经方里大都是指的“调胃承气汤”，用胃气不和这种病理解释用得比较多。这个地方实际上没有里热，如果有里热，用五苓散是解决不了问题的。这个“胃气不和”实际上是说在病理上，胃中水分缺乏得厉害，陷于一种胃中也枯燥的状态，这种状态能够影响到人的精神。它的病理反应，也就是说症状反应有时候跟调胃承气汤的症状反应相似，至少从病理上有些相似的地方，甚至都影响睡眠，让人感觉有点像里热这个

样子，但是它不是里热，它主要的原因是胃中缺水。

“欲得饮水者”，缺水之后人自然的反应就是想喝水，但是不能让他随意地喝。应该怎么治疗呢？方法也非常简单——就是“少少与饮之”，控制一下喝水的量和速度，慢慢地少喝。后边也作了一个病理解释——“令胃气和则愈”，这肯定是古人从临床中得出来的经验。

在生活当中，我记得年轻的时候，有一次夏天出来玩，回去后感觉口干、口燥，我就想一下把它喝够了，一个挺大的凉水杯，得有一升多，一口气咚咚喝下去，我心说这下可真的解渴了。结果胃里难受，最后差一点吐出来。实际上就是那种情况，不管什么都不能过了，过了以后整体失去常态了。所以，如果让他喝水的方法得当了，很快自己就恢复过来。这等于说是一种发汗过了以后，表也解了，剩下的就是单纯的津液虚，治疗的办法也非常简单。这是第一种情况。

第二种情况，还得倒回去从头接着上边，“太阳病，发汗后，大汗出”之后的另一种情况。如果脉浮，脉浮在这儿本身就暗含着有表不解的意思。咱们前边学每一个方证，我们都有脉象的统计。实际上像五苓散证也好，甚至包括其他的表证也不一定全都是浮脉，但是多数情况下有表证现浮脉。这儿拿了典型的脉象说表还没有解，表不解的因素相对的就稍复杂一点，一个是汗出得太多了，在经方理论中，出汗太多有病必不除的后果；另外更重要的一点是什么？从后边的症状和治疗方剂我们能够理解另一层，实际上就是最主要的一层：这是误发了外有表证，里有停饮的这种病人的汗，这是误汗。至于具体到表这一部分的症状，服了发汗剂不一定不对症，但是因为里有饮，单纯地用发汗的方法势必会造成一些变证。这儿论述的情况就是里饮的情况加重了，表现出来小便不利。本来病人体液代谢就不好，有停饮，再进一步地发汗，大量损失人体的津液，就会有明显的小便少这种症状。

说到小便不利，今天有一个病人给我打电话，我有一点体会跟大

家交流下。病人现在正吃着药，近两天出现头晕，特别是早晨起床以后觉得头晕得明显，他以前出现过类似的症状，吃了两三天苓桂术甘汤就好了。这个人学医，中医西医都懂。我就跟他说：你呀还是小便不好。他说没觉得小便不正常啊！我说这个小便不利，不是你想象的那种，比如半天解一次，或者一会儿一次，不一定。如果有时候小便要解的时候老解不出来，或者解完了老是不干净，淋漓不尽，或者一会儿解一次，解的量非常少。这种情况要是说他小便不好，很容易接受，觉得说得对。但是在通常情况下，往往有一些不是很重的停饮证的时候，小便往往被人忽视，不太容易被重视的症状，谁平时没事非记着自己一天解多少次小便，一次大概解多少量，很少有人仔细去记这些东西。所以，常常有一些稍微轻的水饮证，在临床当中被忽视了。我现在临床中往往会问夜里小便什么情况，夜里一般能解几次。今天就有个病人说一般情况晚上是没有小便的，再加上舌质上有齿痕，那就这个停饮证就齐了。

“微热消渴”，这本身是两种性质不同的症状。微热在五苓散证中主要是指表证不解，特别是这一条里最明显；消渴是另一回事。如果从这个角度给这四个字点标点，一定要在微热和消渴之间点上一个顿号或者逗号，它不是一回事。“消渴”既是一个疾病名称，也是一个症状名称。比较权威的解释有三种意思：一种它是因为饮食不节或者情志不调等原因引起的多食，多饮，多尿，形体消瘦，或尿有甜味，以这些为特征的病症。这个病在《素问》里有专门的论述，特别像今天糖尿病，这些症状就是糖尿病的典型症状，当然糖尿病不是一种情况，这是比较典型的那种。第二，它是消渴病的一种，以口渴，尿少为主症，这个论述出在《太平圣惠方》里。第三个仅仅指的一种口渴的症状，这个口渴才是出在《伤寒论》。这应该算是比较权威的解释，是在《中医辞海》里查出来的。但是这个解释恰恰是我们今天学的，第三种情况它解释得不太贴切。应该是口渴欲饮，饮后口渴症

反不得缓解的症状反应，这是我根据经方理论归纳的。我觉得它是好几种情况在一块儿，最后这一项反倒不是很贴切。在经方里本身指的是这类的口渴，喝了水以后不得缓解，甚至更渴。这个口渴是在水饮证里边出现的口渴，是一个比较特殊的情况。像这类的情况，现代医学在这方面的认识反倒是不到位。

关于这个口渴的情况，胡老论述得很多。但是有一点必须得弄清楚：并不是所有的五苓散证都有消渴症状。实际上临床中遇到的五苓散证，真正出现消渴的不是很多，反倒是像白虎加人参汤证出现的比较多，原因比较直接，就是有里热。我想在张仲景时代，也不会是所有的五苓散证都会出现消渴。那么之所以把这个症状拿出来，是因为这个症状在停饮证里比较特殊。停饮证不仅仅是程度要重，而且还非得是具备了五苓散证这种特征的时候，它才会出现这种停饮。一般情况下停饮证是不口渴的，甚至有的口水多，凡是那个小孩子流口水的，他必是胃中津液太多。要是让它吃五苓散有点不太现实，给他肚脐上贴上五苓散，偏寒的再合上理中汤，它绝对能够改善这种情况。实际上，平时一般停饮不大厉害，特别是胃中停饮严重的时候，反倒是像理中汤、吴茱萸汤都有吐涎沫的那种情况，就说实际上是口水多。五苓散证的消渴跟白虎加人参汤证的消渴不是一回事，它的原理是因为旧水不能顺利地排出去，同时这个消化系统（也就是胃肠）对于水分的吸收呢又不好，这样就形成了旧水不能出去，新水又不能吸收。新水不能吸收，绝对是它有胃肠对水分吸收不好的一方面因素，另一方面就是还有旧水不能排出，逐渐地停水太多，以至于新水近乎一种饱和状态，等于这两个方面的因素促成了这么一种状态。就是说旧水排不出去，影响新水的吸收；新鲜的水分吸收不了，它就不能起到濡养肌体的作用。没有这个作用，脏腑组织甚至包括细胞都会处在一种缺乏新鲜水分的状态，自然就会感觉到渴。有人说人体是智能的，它会给人一个生理上的反映，感觉想喝水，就应该喝水。这样呢，出现了

口渴，但是喝了水以后还吸收不了，那么它还会渴。这样喝到一定程度，水分太多了，它就从嘴里边再吐出来，“水入口则吐”，这是后边条文里的论述。

这里还有一个问题，它后边说“五苓散主之”，也就是说它前边论述的这些症状是五苓散主治之证。五苓散主治之证，要如果再回过头来一想，就会发现里边还有一个表证呢，不仅仅是一个停饮的问题，里边还有一个表证不解的问题。五苓散里一大堆去水的药，只有少量的桂枝，它怎么能够解表呢？咱们简单的分析一下五苓散解表的机理吧。首先应该肯定的一点，五苓散之所以能够解表，这个表证必须是五苓散方证范畴之内的。比如表实证表实证里有停饮的，就是小青龙汤证，或者是小青龙加石膏汤证，那就不是五苓散所能治的了，尽管它也是外有表证、内有停饮，那就不是五苓散治的了。

所以说五苓散治的表证，一般它得是表虚证，五苓散并不是一个治疗表证的专方，它能治一部分表证，但不是所有的表证都能治。这是一种什么道理呢？首先，五苓散证又带有表证，是因为它本身就有表证，服了发汗药以后发汗过多，再加上发汗药本身就用错了，因为它里有停饮，应该一边发汗一边有祛水的药才对，所以表证不除也是情理之中的事。在临床中我碰到过这样的病人，小男孩特别胖，他小便一会儿一解，一会儿一解，发烧浑身没力气，那就是一个标准的五苓散证，发烧实际上就是感冒了。这种情况下喝五苓散就能好。五苓散怎么能把表证治好了的呢？就凭那么一点点的桂枝它就能治好表证吗？我们应该从更高一点的角度来认识人体，认识病理，这点很重要。人体本身就是一个有机的整体，人体的能量是有限的。像五苓散证外有表证里又有停饮的这种情况，首先它肯定停饮是主要矛盾的。它里有停饮的情况下，还有能力在体表的层面与疾病作斗争，说明人体的体能还是相对比较强的。这个时候如果用了五苓散，实际上它首先解决的是里有停饮的问题。停饮的问题解决了很重要，我们打个比

方，比如把人体比作一个城市，市郊出问题乱了，同时市政府里也出了问题了，这个时候如果把市政府的问题先解决了，市政府就会按部就班的工作起来，分管市郊的机构就会去尽它的职能，把事态平息了。其实人体也是这样，它本来里有停饮外有表证，在里有停饮的情况下，它还有能力跟表证做斗争的，如果把里面的停饮给解决了，里边的状态好了，那么它与表证作斗争的能量也会得到补充，有多余的能量就会补充到体表来，这个时候表证也就会恢复得比较快，再加上这个方剂里又有一味桂枝，它本身就有实表的作用。

所以，五苓散证的病理应该是水证兼阳性表虚证，就是里饮证兼阳性表虚证。但是仔细推敲一下，它应该是水证重于表证，水证是主要矛盾。

这一条做一个小结：本为太阳表证，服发汗药后致使大汗出，则可能会出现两种以口渴、欲饮为主要特征的情况：一种是由于胃中津液虚损，表现为燥烦不得眠，欲得饮水的，可以让其少量缓慢的适量地饮水，让胃功能慢慢恢复即可痊愈；另一种则是患者素有里饮，发汗后，不单表证未能解除，里饮反随之加重，表现为脉浮、小便不利，微热消渴的，为五苓散主之之证。

五苓散一共有五味药组成，有猪苓、泽泻、白术、茯苓、桂枝。在《伤寒论》的方剂里，五苓散的剂量是比较独特一点的，猪苓是十八铢，泽泻是一两六铢，白术、茯苓都是用的十八铢，桂枝用的是半两。这个重量折算起来有一点麻烦，我按它那个重量算下来是：猪苓约 12 克、泽泻约 20 克、白术约 12 克、茯苓约 12 克、桂枝约是 8 克。汉朝的一两等于 24 铢，大家算一下就行了。为什么给大家折算这个？因为它这个剂量让人看了比较零散一些，再就是它这个药量的变化，比如泽泻比其他的药又多，但又多不了一倍，而且这五味药的比例关系还是挺重要的，有人专门做过试验，把这五味药的比例在病人身上做实验，最终的结论原方的比例是最好的。所以，在应用过程

中，没有特殊情况就严格按照这个比例。

这个方剂它是集众多的常用祛水药于一身，猪苓、泽泻、白术、茯苓都是常用的祛水药。为什么说常用呢？因为还有其它很多祛水药不常用，像葶苈子，还有些有毒的像甘遂等。这四味祛水药出现频率很高，药性也比较平和，像甘遂那类的药是剧毒的了，但是它祛水的能力也很强，必须在一些很特殊的情况下才用到它。正因为这个方剂集众多的祛水药于一身，所以它祛水的能力非常强，而且这个方剂的寒热倾向也不是特别明显，猪苓和泽泻是偏于寒性的，猪苓和泽泻的量加到一块相对也比较大，白术和桂枝是偏于温性的，茯苓是中性的，就是说它的寒热倾向不明显，猪苓在祛水的同时还有止渴的作用。这五味药组合到一块儿，恰好形成了对应五苓散证的格局。值得一提的是桂枝这味药，它的作用主要的就是降气冲，它起到为了减少因为气上冲的趋势影响体液下行的作用。加上桂枝以后，凡是有轻微表证的反倒是顺便就能解除了。当然没有表证也要用桂枝，实际临床中五苓散证有表证的机会不是很多，常常都是为了解决水饮的问题。

在方后注解里有一个服用方法，这个散剂在服用时要求用白饮和服。白饮就是今天的米汤，就是熬米饭的稀汤。为什么要用这个来喝呢？这个方剂是直接服药粉，药粉相对地有刺激性，喝到嘴里不舒服，米汤黏糊糊的，就能减少这种刺激。有人用牛奶服这个散剂，其实也未尝不可，也没有什么大的问题。

在条文的最后，《宋本》里有“即猪苓散是”五个字，这五个字绝对是错误的。因为从内容说，这五个字不是原文里的，《宋本》这五个字也是以小号字排的，它本身是注解文字，《康平本》里没有。这应该是在《康平本》之后的某个时期加上的，但是加的毫无道理。因为猪苓散是《金匱要略》里的一个方剂，它和五苓散之间的药物组成不一样、主治也相差很远。

如果我们结合临床，有一个服散与服汤的区别问题。临床中很多

医生都喜欢把它改成汤剂用。实际上大家看看它这个原方，原方要如果说散剂的话，剂量完全没有必要是这样的，用“份”就可以。那么它为什么用了“十几铢”这样的计量办法？这个计量做散用、做汤剂是没有问题的，直接它这个剂量做汤剂就可以。现在用汤剂恐怕更多的考虑是什么？一个是散剂利润就比较低，它少啊，用药量非常少。古代加工不太方便，特别是没有粉碎机的情况下，这五味药如果做成散，那需要得有一段时间的体力劳动才能加工成药粉。之所以原文里要求用散，应该散剂的疗效比汤剂要好。这么多年好多医生都是把它变成汤剂来用，很少有报道说因为汤剂和散剂的区别影响了疗效。

可是确确实实也有这种情况。有一个朋友他就碰到过这种情况，他给他母亲开的五苓散汤剂，喝了以后疗效不好，甚至说没有疗效，而且还不舒服。后来改成散剂，喝了以后疗效很好。这是一个非常有说服力的例子。他得出一个结论：凡是经方里要求用散服的都不要改成汤剂，服散剂的疗效更好。虽然这种结论有点太武断了，因为在临床中很多人都把它用汤剂疗效也没明显差别，但是也确实存在他这种情况，应该重视起来，理性地分析它。为什么有的人服了汤剂不如服散剂疗效好呢？像这样的人他肯定是胃里边停饮重，因为汤剂大部分都是水，胃这时候就对液体的东西有些抗拒的作用。五苓散它就有这么一个特点，严重了喝水就吐，但是吃了食物不吐。古人对这些东西已经总结得非常的细了，像胃吸收水的功能特别不好的这种人，用散剂疗效就比较好。恐怕这就是古人不惜费那么多的劲，把它做成散剂的原因所在。如果是一般的停饮，要是五苓散证，用汤剂也没有多大的问题，因为在实践中多少人都做过试验了。

五苓散这是一个常用的方剂，医案很多，这儿就捡些典型的在这儿说。有娘儿俩，儿子三岁多不到四岁，春节以前的时候出现上吐下泻，他母亲来看病的时候说的，没带孩子过来。后来我就用比较保守的办法，给了他一点理中汤，让他吃一次以后看效果给我打电话。她

回去让孩子吃完了以后，说没有什么变化，而且拉肚子也不见轻。我让她赶紧回来拿药，换另外一种药。像这一类都是老病人了，比较熟了，一般新的病人要这样他会觉得你医术不好。我就又给了五苓散，就吃了一次上吐下泻结束了，后来又吃了两天就好了，到现在也没有出现过这种情况。像有些小孩吐乳症、小儿腹泻这类的情况比较多，但是你也得细辨证，真要是里虚寒的理中汤证出现的腹泻，五苓散也治不了。这说的是儿子，再说母亲，就前两天她突然打电话说，这个腋下（其实就是胁部）胀、痛，吃饭食欲不好，再就是头晕。我给她的药就是小柴胡汤合上五苓散，因为方剂都是都现成的，小柴胡汤给了10克，五苓散10克，合在一块儿。她大概吃了一天，第二天就给我打电话说吃了以后觉得累、困，睡得特别的好。我说这个累是正常情况，应该有的情况，睡得深是好情况，最好能多抽点时间休息。她说食欲明显地改善，怕这样吃下去又得胖起来了！这就是药对症了。她前边吃了一段时间药，吃的是吴茱萸合上当归芍药散。因为她始终有水饮的问题，那个时候她有吴茱萸汤证，吃了一段时间以后她食欲也好了，慢慢都好了。她这段时间又有一点忙，实际上她身体里边的的问题基本摆平了，她还有贫血，贫血、水饮、里虚寒证基本上都摆平了，但是水饮的问题又出来了，半表半里证又出来了，又开始不愿意吃饭，就给她这个方剂，比较对证，她到现在还在吃着，每天吃得很多。

这个方剂是个常用的方剂，方证也比较复杂一些，它本身是个水证嘛。统计到的医案是500例，症状顺序是从出现次数最多的往出现次数最低的地方说：小便不利、呕吐、口渴、浮肿、发热、头痛、恶风、汗出、水入则吐、头目眩晕、少腹胀满、身重、下利，脐下动悸、吐涎沫、短气、咳嗽。

舌质：淡舌、红舌，舌体胖大，淡红舌，暗舌。

舌苔：白苔、白腻苔、白滑苔、薄黄苔、黄腻苔、苔白厚干。

脉象：浮数、沉细、细弱、弦滑、弦。按单脉像来统计，它表现为沉、弦、细、数、浮、滑。

应用五苓散方剂的现代疾病有：慢性肾炎、急性肾炎、肾小球肾炎、肾盂肾炎、肾炎水肿、早期肾功能不全、膀胱炎、晚期膀胱癌、泌尿系感染、泌尿系结石、糖尿病、尿潴留、肾病综合症、淋病合并睾丸炎、阳痿、水疝、结扎后并发阴囊水肿、肺源性心脏病心力衰竭、慢性充血性心力衰竭、结核性渗出性胸膜炎、胸腔积水、肺水肿、三叉神经痛、美尼尔综合症、神经抑郁症、神经官能症之头晕、偏头痛、顽固性头痛、眩晕、脑积水、带状疱疹、荨麻疹、脱发、斑秃、多形性红斑、尿崩症、急性胃肠炎、慢性肝炎、脂肪肝、流行性腹泻、腹泻引起脱水，脱水症、经前期紧张综合症、行经浮肿、慢性盆腔炎、妊娠高血压综合症、羊水过多、卵巢囊肿、乳腺小叶增生、带下、行经泄泻、胎水肿满、妊娠小便不利、小儿吐乳症、百日咳、消化不良、幼儿腹泻、小儿呕吐、婴儿秋季腹泻、小儿流行性腮腺炎、麻疹、瘰疬症、遗尿、青光眼、过敏性鼻炎、中耳炎、触发性耳聋、慢性轴性视神经炎、中心性视网膜脉络膜炎、中心性浆液型视网膜脉络膜病变、自汗、盗汗、胰头癌压迫胆总管致梗阻性黄疸。

这儿有两个需要客观看待的原因，就是水证本身所造成的疾病就比较复杂，这是其一；另外一个，后世的医家用五苓散的时候喜欢加减，这个加减的因素也会造成它的疾病谱比较宽泛。

发汗已、脉浮数、烦渴者、五苓散主之、（72）

猪苓十八铢去皮 泽泻一两六铢 白术十八铢 茯苓十八铢
桂枝半两去皮

右五味、捣为散、以白饮和、服方寸匕、日三服、多饮

暖水、汗出愈、如法将息、

胡希恕：那么就是方才说的了，凡是小便不利，里有停水，发汗表不解，那么这个也重复，这个很要紧啊，在临床上一个人得感冒了，他小便不利，你给他吃解表药是决不行的，必须利水。这一段他又重复这么一段，他说发汗以后，脉仍浮数，这表不解嘛，而现反而烦，渴。也烦，烦就是有热的烦，也渴，这就是误发了小便不利、里有停水人的汗了，那你给五苓散就对了。当然这里头可要注意，他应该有个小便不利，因为上一段他说了，这一段他简略了。假设没有小便不利，你们看看这个脉证，那不一定得用五苓散了，脉浮数而烦渴，这与白虎汤证差不多了，尤其白虎加人参（汤证），脉浮数，烦渴引饮，那不是白虎加人参汤（证）嘛。他有小便不利，所以这一段的意思就是这个意思，让你与白虎汤证做比较。白虎汤证口舌干燥，烦渴，脉也浮数呀，但是他没有小便不利。这个五苓散证啊，有小便不利，虽然也烦渴，脉浮数，他有小便不利，那么这一段应该有个小便不利，因为详说在头一条了，那么这一条就简略了。

李冠杰：这一条也是一个顶格的条文。

这条在《宋本》和《康平本》的排版当中有个不同，《康平本》是在第 72 条之后，附上了五苓散的方及方后注。《宋本》把这个方和方后注呢往前提了，提到 71 条之后，这样 72 条和 71 条之间就隔了一个方剂，实际上《康平本》这两条是挨着的，这个调整无意当中削弱了这两条之间的联系，它们在病理上是有着内在联系的。

下边咱们解读一下：

这个条文所论述的同样是错误地对外有表证里有停饮的这种错误施以汗法，但是它的症状表现反应却跟上一条不尽相同。这样呢一方面它拓宽了五苓散证的应用指证，另一方面的意义是说五苓散证，不是仅仅上面说的一个，在近似病因的情况下，它出现的反应会不一样。有时候会出现以 71 条那种反应为主要的证候；有时候会出现像

这条里面论述的这种症状为主要的证候。

“发汗已，脉浮数，烦渴者”，仅从字面上看像脉浮数、烦渴，还不能确定，你不能把它辨为是五苓散证。发汗以后，人体因为津液虚损又有里热出现的这种情况的时候，比如白虎加人参汤证，它也会出现这种症状，要想理解它，就得参照后边的方剂，这实际上是对里有停饮的人误施以汗法。这里主要的还是它有表证仍不解的这么一种情况。我们刚刚学过的第 57 条“伤寒发汗已解，半日许复烦，脉浮数者”，后面怎么解决呢？还是要用桂枝汤，可以更发汗，“宜用桂枝汤”。实际上它这说的就是跟我们这条讨论的表证的这一部分是类似的，所以大家看这个条文最前面“发汗已”，它没用发汗后，本身就有可能跟这条论述的比较相似。刚刚吃过发汗药以后，有那么几个小时的时间看似表证好了，但是呢后来又出现……表证实际上没解。但是这条里面的问题更复杂了，又有一个里饮的问题，烦的同时再和渴结合到一块，这里面除了表证的因素以外，它还有一个人体组织缺水失养以后，也会让人有一种烦的那种症状，应该说这也是一种里饮证重证的一个症状反应。从这儿也能看出来这个水饮证本身就是一个比较复杂的情况，所以说这个地方又论述了一种新的停饮证的一种表现。根据这个治疗的方剂，我们还应该想到患者至少还有小便不利等等的一大堆体液代谢不好的那些症状。因为前面一条有论述，后边又有方剂，所以在这儿就全都省略了。要仅仅是条文里面说得那么简单的话，把它作为五苓散证那是不太确切的。

下面作一个小结：服发汗药以后，出现脉浮数烦渴的，为五苓散主治之证。

这个条文大家必须心里有这么一个点，就是说它说的这个症状太简单，如果说没有后面的方剂给我们标着，它前面说的这个也不成立。

伤寒汗出而渴者、五苓散主之、小渴者、茯苓甘草汤主之、（73）

茯苓二两 桂枝二两去皮 甘草一两炙 生姜三两切

右四味、以水四升、煮取二升、去滓分温三服、

胡希恕：这一段更简了，也是根据前一条说的，本来就是伤寒，无汗的伤寒证，那么经过发汗汗出，而渴者，也就是表不解而烦渴的，还是有小便不利，还得用这个，他这个五苓散主之呀，他就让你看头前，他这个书啊就是这样。假设要没有这些话，那么就是伤寒，汗出而渴，就用五苓散，那是错的，尤其底下这句话，不渴了，那么就喝茯苓甘草汤了，就更错了，就不可理解了。主要这一段给五苓散与茯苓甘草汤并提出来，让你鉴别，鉴别的方法就这两个方剂是渴、不渴的关系。那么这个五苓散证呢，你得根据头前这个说法，仍然有脉浮、小便不利而渴者，用五苓散。那么上证不渴的话，可以给茯苓甘草汤，是这么个意思。这个茯苓甘草汤啊也是桂枝甘草汤的加减方，加茯苓，加生姜。这个茯苓量用得非常重了，这个二两是错的，在《玉函经》就是三两，顶少得搁三两，因为这个方剂在厥阴篇里头还有这么一段，他说的伤寒，厥而心下悸，应该给这个茯苓甘草汤，他说不然的话，水气入胃，必做利也，这个意思是什么意思呢？你看这个药物组成就看出来了，既有桂枝，又有生姜，这个水气冲逆，水往上合气冲的气，逆满心下而心下悸，心下就是胃口这块呀，这个水 and 气都往上来，甚至于人就要呕的，所以他心下悸，那么这个在这段都没明说，这个在这段的主要意思，就是五苓散与茯苓甘草汤的鉴别点就是渴与不渴的问题。我们用这个方剂，只是不渴就用它，是错的，主要得心下悸，气冲、心下悸，或者有呕逆，这个生姜嘛，而小便不利，也得有小便不利，我们才能用茯苓甘草汤。他不渴，不但没有猪苓，同时呢利尿的作用照五苓散差多了，他影响不到消渴的程度上。那么这个方剂呀

也很常用，茯苓甘草汤，一般由于里有停水失眠啊，这个方剂也挺好使，这个方剂加上这个龙骨、牡蛎，治心悸、失眠，我常用这个方子，挺好使挺好使。假设遇到顽固的失眠证，那么他有这个心下悸得厉害，用其他的药不行，你用这个药，每每见效。龙骨、牡蛎都可以搁 12 克，一样搁 12 克，很好使。这个茯苓可以加重，要是治失眠的话，茯苓起码要搁 4 两，4 两就是 12 克，还可以加，茯苓关于神经方面的证候用得相当多。这两个方剂的比较啊，其他都类似五苓散证，五苓散也有心下悸呀，也有茯苓嘛。那么同时五苓散治消渴，这个不渴。

李冠杰：这个条文也是顶格条文。

这条里面的“小渴者”，在《宋本》里面是“不渴者”。这里面差距就大了，这就是一个原则问题。这本身症状就这么一个症状，而且一个是渴，一个是不渴。所以必须得把它弄清楚。下边咱们会具体地分析。

下边我们解读一下：

伤寒经过发汗以后，出现以停饮证为主的两种常见方证的鉴别，这是条文的中心意思。茯苓甘草汤证在这儿就这么一个症状，“小渴”，《宋本》里面是“不渴”。应该说《宋本》里面的“不渴”是正确的。

为什么呢？首先从技术方面说，这个“小”和“不”这两个字，从字型上比较接近，要如果说是手写的话，这个“不”字写草书的时候跟“小”字特别相似。也不排除另外一个因素，上面这一横因为某种原因比如说虫蛀了，或者说是其他的因素呀给划掉了，也让人感觉像是一个“小”字，从技术方面来说，容易出现这样的错误。

咱们再从内容上来分析一下。这个“渴”与“小渴”，就是一个程度上的问题，要如果把这个问题当作两个方剂的一个鉴别点的话，你很难形成一个鉴别标准。其实五苓散证有时候，也未必就渴得很厉害，甚至有的不渴。具体分析茯苓甘草汤方证的话，是以胃中停饮为主的。所以说这个方证一般不会出现口渴，我们临床当中也是这样，

你很少会看到茯苓甘草汤证的患者，说他口渴得厉害或者口渴得明显，这种情况很少。那么五苓散证要如果也出现不渴呢，这儿指的是重症，一旦到了重症的程度，五苓散证就会出现口渴的。

这个条文论述的，还是对外有表证里有停饮的这种误施以汗法，而出现的变证。因为这两个方证，在病理上和症状反应上都比较接近，所以说呢在这儿提醒大家，要注意鉴别。五苓散证是外有表证里有停饮；茯苓甘草汤证也是外有表证里有停饮。如果仔细比较的话，这两个方证还是有区别的。这两个方剂对的表证都是表虚证，五苓散证是以水证重于表证；而茯苓甘草汤证是水证和表证并重。

下面做个小结：对于外有表证、里有停饮的患者，如果误施以汗法，若表不得解、汗出而渴的，为五苓散主治之证；若不渴的，则为茯苓甘草汤主治之证。

下面呢，看一看茯苓甘草汤这个方剂。茯苓甘草汤由四味药组成，茯苓二两，桂枝二两，甘草一两，生姜三两。

这个方剂啊，可以理解成桂枝汤去芍药大枣加了茯苓。桂枝汤中的解表剂都在、都有，所以说这个方剂解表的力量比五苓散的力量要重。同时呢，这个方剂也可以理解为桂枝甘草汤加生姜茯苓。也就是在桂枝甘草汤实表降气冲的基础上，加强改善胃功能的同时祛水，既改善胃功能又祛水，茯苓生姜都有这方面的功能。生姜在这里不仅仅可以改善胃功能，还可以祛水，而且有解表的功能，在这个方剂里面起的作用比较重要。但是我们在临床应用当中，好多人都忽略了它的解表功能。实际上啊，表虚证同时又有停饮的这种情况，用这个方剂还是比较好用。而且这个方剂呢，有一个很重要的特征，就是以胃中停饮为主。就是胃这个地方跳，做腹诊的时候让病人躺平了，用手放到胃的这个地方，跳的频率跟心脏跳的频率是相同的，有的人还非常明显。

如果再延伸的话，胡老说用这个方剂加上龙骨牡蛎治失眠。但是

这个失眠得是以茯苓甘草汤证为基础的。

我这儿有一个医案，大家听了之后，应该印象会比较深。这是一个 25、6 岁的年青的老师，她跟我说：为了治失眠，她跑到济南去治了，抽屉里面的药都满了，但是没有管用的。她觉得很愁的慌，后来跑到我这里来了。我就问她，她就坐在那，一边哭一边说。她是什么情况？她姐妹两个人，妹妹比她小两三岁，她毕业以后，她父母花了一些钱为她找到工作，结果她妹妹长大了以后，家里边没有那么多钱为她妹妹用同样的方式再去找工作，所以她妹妹把所有的不满全都撒到她身上，整天给她脸色看，家里边的电脑，她妹妹也搬到自己房间里边去，特意不让她玩，所以说她很郁闷，再加上她感情方面有一点不太顺利，就这么形成了失眠。后来我就说做个腹诊吧，我一摠肚子，心下跳动剧烈，太明显了。我又问她其他的，她甚至连柴胡证都没有，其他的证都没有，吃喝什么的都很正常，包括大小便。我想就应该是这种证。后来我就跟她说啊，你啊是胃这方面有点不太好，体液代谢也不太好。我跟她说了以后，她母亲就跟我说了，她说：你怎么什么都知道啊？她说：我们前面跑到别的医生那儿看，他也给按肚子，按完肚子以后他把我叫一边去，他说你这个姑娘结婚了吗？我这孩子还没有结婚呢。你这孩子可能是怀孕了，有胎动啊。实际上这就是读书读得太死板了。《金匱要略》里边有那么句话，胎动在脐上，在脐上那不是胎动，那个就是一种比喻，像胎动一样在脐上，就那个意思。但是他们就理解成那个，他就怀疑人家怀了孕了。后来我就给她这个方剂，就是茯苓甘草汤加上龙骨牡蛎。结果她吃了以后啊，当天晚上就迷迷糊糊反正不知不觉地就睡着了。她给我打电话说，第二天就睡得更好了。从那以后直到现在，再也没有出现过失眠。

给大家一个提示，茯苓甘草汤加上龙骨牡蛎这六味药，大家想想柴胡加龙骨牡蛎汤里边，几乎就包括了 this 方剂。那么它治什么？治精神方面的一些疾病。因为胃中停饮然后又影响到精神方面。就这一

方面的，你加上龙骨牡蛎就比较好用。

这个方证呢，比较典型的症状：心下悸、汗出、四肢厥逆、小便不利、头晕、咳嗽。

舌质：淡舌、红舌。

舌苔：白苔、腻苔、薄苔。

脉象：沉脉、弦脉、数脉、缓脉、还有结代脉，细脉、弱脉。

对应的现代病：冠心病、甲亢型心脏病、心衰、急慢性胃炎、肝硬化腹水、肝炎、慢性肾盂肾炎、经前期紧张综合症、水泡性结膜炎。从这个方剂的统计资料上看，临床当中对这个方剂理解得都不是特别好。

实际上这个病挺常见，很多人在胃口这个地方，有很多病啊。我治疗过一个胆囊炎，他不仅仅有柴胡证，而且每次给他腹诊都会有胃口这儿跳。我尝试小柴胡汤合上茯苓甘草汤，再合上其他的，他有淤血的，会合上一些治疗淤血的方剂。他吃了以后，感觉疗效比较好。

中风发热、六七日不解而烦、有表里证·渴欲饮水、水入口吐者、五苓散主之、名曰水逆·（74）

胡希恕：他说“六七日不解而烦”，原起这个人得的是中风证，中风没有不发热的，在六七日这么一个过程，当然是暗中就是说已经服过桂枝汤了，还不解，这个人啊反而烦。不解指着表不解了，“有表里证”，表证就是上面说的不解，还是中风发热那种证，里证就指着下面这个水逆，饮水则吐这个水逆。他说“有表里证”，这也是倒装句，先把结论搁头前了，底下详细解释。“渴欲饮水，水入则吐者”，这五苓散证就渴，渴，喝还渴，这叫消渴嘛，你怎么样子喝，也不吸收，这胃停水多了就要呕吐，所以“水入则吐者，名曰水逆”，吃东西不吐，就是水在胃停多了，水下不去，那么专吐水，可是渴，一喝

就吐，那么这叫作水逆证，当然也用五苓散治之。开始是消渴，小便不利，有发热，微热，那么这个时候就吃五苓散就好了，不至于得水逆，这个时候再延迟，不利小便，一直喝，这个水喝到相当程度，再喝就要吐了，这叫做水逆。这个水逆还是五苓散证的继续，所以仍然用五苓散。

李冠杰：“中风发热，六七日不解而烦（旁注：有表里证），渴欲饮水，水入口吐者，五苓散主之”。后边又一个小旁注：“名曰水逆”。这个条文也是一个顶格的条文，其中有两处的旁注。这个“水入口吐者”，在《宋本》里是“水入则吐者”。大家慢慢品味品味，明显能感觉到《宋本》是对《康平本》的润色，觉得这个句子读着不太顺嘴儿，有时候会改一改。

下面解读一下：

“中风发热”，这明显的就是太阳表虚证了。“六七日不解而烦”，是说病程比较长而且它还出了新的症状。“六七日”不是具体的日子，是说患了太阳表虚证已经很多日不解了，应该说六七日在经方里已经是比较长的，比它再长的那就是“十余日不解”了这一类的，意思就是说病程比较长了。这个“烦”既有表不解的因素，同时又有里饮、停饮的一个因素存在。

“有表里证”是一个旁注的文字，加的注解。这个注解如果把它理解得恰当了，它可以起到一个解释的作用。应该怎么理解呢？应该理解成：“表里证”——有表证，这是毫无疑问的；那么“里证”就是里有停饮。

“渴欲饮水”是五苓散证的一个主要的症状反应。

下边“水入口吐者”，或者说“水入口则吐”也行，它说的是饮了水以后不久，马上就要吐出来。这也是五苓散证一个较为典型的特殊症状反应。你像前面我们说的关于散剂和汤剂的问题，这一类的情況就比较适合服散。它这个“水入口则吐”啊，五苓散证本身就因为

停饮造成组织缺水出现的口渴，饮了水以后它还不能及时地消化、吸收，停在胃中，停水停滞得多了，就会出现胃中装不下水了，喝进水去以后就吐。比如前段时间，电视上播了一个小男孩，吐水，哗哗的往外吐，就在那个镜头上，一吐吐一大片，肚子老大，他可能就是一个五苓散证。

另一个方面，并不是说所有的五苓散证都会出现呕吐的情况。所以，必然还会有另一个因素，那就是胃中停饮是一个比较重要的环节，胃对水饮的吸收已经差到了极点，可以说基本上不吸收水了，这也是一个以胃中停饮为主要点的五苓散证的反应。比如五苓散证，有时候它会表现为腹泻，它就是肠子里停饮的情况严重，出现单纯的腹泻，就是大便稀了，溏泻；它有时候会表现为浮肿，就是体表停饮就比较重。停饮的部位不同，它表现出来的症状也会有所侧重。

最后加了一个“名曰水逆”，也是后人加的旁注文字。实际上这是后世的注家根据它的症状特点总结的这么一个疾病名字。有这个名字可以帮助我们记住这个病，而且能比较好的反映疾病的病理特征，这也算是经方理论的一个延伸。

下边作一个小结：患太阳中风证已有六七日以上的时间，不仅有发热等表不解的症状，而且还出现了烦的症状，同时表现为渴欲饮水，但是水入口则吐，这是由于外有表证、里有停饮的缘故，为五苓散主治之证。后世称之为水逆证。

在临床当中，像这个方证也不仅仅是上面讨论的这么几个症状，最起码也得有小便不利这一类的症状，总之就是水饮病它本身比较错综复杂，它不是一个方面。古人写书，他就拣有用的、重要的、有代表性的说，但是我们不能机械地去理解。=

未持脉时，病人叉手自冒心、师因教试令咳、而不咳者、

此必两耳聋无闻也、所以然者、重以发汗虚故也、（75）

发汗后、饮水多必喘、以水灌之亦喘、（75）

胡希恕：“未持脉时，病人手叉自冒心，师因教试令咳而不咳者，此必两耳聋无闻也，所以然者，以重发汗虚故如此”。这是一段，下面应该是另一段。“未持脉时”，就是这病人来到，还没诊脉呢，看着情形，那么这个人“叉手自冒心”，交叉着手按着心下的部位，这就很清楚了，桂枝甘草汤头前讲过了，气往上冲得厉害，心也跳得厉害，他按着这个地方比较舒服，叉手自冒心，心下悸，欲得按。那么我们看着这个病人就看出这种情形了，不用诊脉就知道他是发汗太多了，亡失津液太多，他亡津液亡血液，血不足以养心就心下悸，尤其这个气上冲也厉害。“师因教试令咳”，他看看这个丧失津液血液这个程度，如果要厉害的时候，他必耳聋，所以要试验试验，“因教试令咳”，你咳嗽咳嗽。他耳朵聋他听不着啊，他也不咳嗽，从这可以明明白白看出来发汗太厉害了，不但心还必须得按，耳朵，这津液不能灌于上了，所以血不荣于哪，哪就不好使呀，他两耳已经聋了。这就是中医讲的望闻问切了，你不用诊脉，在这个情形之下，就可以看出这个误治的结果。这是一节，主要的是由于发汗太过，亡津液亡血液，气冲、心悸、耳聋，造成这种情况。我遇到这个病，那耳朵聋得一半时好不了，他总得津液恢复之后，逐渐逐渐就好了。底下这是又一条了，“发汗后，饮水多，必喘；以水灌之，亦喘”，这就根据那一条，“胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之”，就根据那条来的。由于发汗，丧失水分太多，胃里头水也被夺，胃中干，那么这个时候给他喝水，一点点给他喝，不要大灌，“饮水多，必喘”，这就是根据那条来的。所以他一时猛喝，他渴嘛，可是这个水汪到胃里头，一半时不吸收，尤其在病人的胃都不好，那么在胃里头停水，压迫横膈膜，他呼吸就困难，他就喘。“以水灌之，亦喘”，拿水灌之，是古人治病一个方法，拿水浇身，这就现在西医用冰袋是一个方

法。他是本来里头有停水，就根据五苓散那地方来的了，发汗，表不解，身上发热。那么这个去热的法子，古人用浇水的办法，拿水灌之，这个也不行。凡是这个表证啊，如果表不解，详细斟酌所以表不解的道理来，古人有用水灌之之法，一灌之使这个热不得外出，热壅于里一定要喘的。所以这一点都是非法的治疗，现在在中医没有拿水灌之的了。他这个病在临床上必须分表里的，那么这个病人发热，他是表证，你非使之由表解不可，由表解的方法多端了，他如果小便不利，你利小便就可以了，这表也解了，是不是。你要从外往里头治，越治越坏。我们在临床上常遭遇的事情，你象风湿这类的病，它也在表，应该由里吃药，让它由外解，所以这个烤电啊，这我可不是随便反对西医了，这种治疗都是违背治疗原则的。你们观察吧，凡是由外治关节炎的，好的很少很少的，治来治去都是这个病越治越往里，出来其他的毛病。它是表证啊，这个表证咱们讲太阳病，头一回就讲了，这个表证什么意思，就是这个疾病在人体的良能上，愿意由表来解除疾病而发生的病，发生这种证。那么这个大夫呢应该因势利导嘛，这个病要由表解，你想方设法让它由表解，你要往里头捂，越捂越坏，这是违背治疗的原则。所以以水灌之这种法子也是不对头，所以他也喘，他这个热不得却于外而壅于里，他一定要喘的。

李冠杰：“未持脉时，病人叉手自冒心，师因教试令咳，而不咳者，此必两耳聋无闻也（“耳”在《康平本》里是个缺字符号），所以然者，重以发汗虚故也”。那么这个条文在《康平本》里边，是降两字格排版的条文。

“重以发汗虚故也”，在《宋本》里边是“以重发汗虚故如此”，语句有点区别，但是实际意思没有质的区别。还有，这一条条文在《宋本》里和下一条条文是同一段的内容，都是第 75 条，但是在《康平本》里边它是分为两段。实际上这两条论述的问题还是有区别的。我们把它分开来学。

因为这一条比较特殊，我们学习也把它颠倒一下，先做一个直译，把小结拿到前面来，后面我们再作一个解读。

小结：还没有诊脉时，病人叉手自冒心（即胸前），医生见状便要求其咳嗽一下，如果病人并没有按照医生的要求做，则说明两耳已丧失了正常的听力，而未能听到医生的话，这是因为重用发汗的方法致人体陷于虚证的缘故。

下边解读一下：

你看这个条文，他用了一个非常生动的诊断实例，来论述发汗太过以后，对人体造成的一种比较严重的不良的后果。在四诊之前，人已经因为发汗太过，造成身体比较严重的虚弱，两个手扶到胸前这个地方，就说人体已经比较虚弱了。实际这是一个望诊的过程，从病人的外貌和举止上，来发现能够反映身体状态的一些症状。我们在临床当中，望诊其实也是重要的一个内容，它可以给我们提供很多的信息。但是我们在平时交流、学习的时候，这些东西常常会被忽视。因为这些东西作为临床医生来说，大部分都形成了下意识了，他拿眼瞟一下，就有了一个大概的印象了。我们从望诊当中能得到什么？年龄、性别、身高、体重、精神状态、肢体灵活程度、眼神、肤色、肤质、毛发、指甲、骨骼变形等等，我们就能得到很多有用的信息。我常常就有这种感觉，病人在门口一推门的时候，我看到他的这一眼，实际上这个诊断就已经开始了，来两个人，我会去判断大概哪一个是病人，一些基本的信息，心里边就有一个大概齐了。

“师因教试令咳”，这儿说的很生动，也很具体，其实不过就是举了一个诊断的方法。临床当中医生给病人看病，有不用语言交流的吗？恐怕很少。就算是以脉诊见长的，经常打着一种旗号，就是说我不用说话，我一摸脉就知道你生什么病。就算这样，也得提前有一个语言的交流，他得说出来，说出来以后，对方得听见，听见以后总得有一个反应啊。实际上用不着真的让人去咳嗽，“你咳嗽咳嗽”，这

个地方说得特别生动，弄得非常地具体，但实际临床当中，像这种没有太大用处，有多少人用“你咳嗽咳嗽”？除非你想知道他咳嗽的声音是什么样。这个地方要看这个具体内容，你仔细分析，价值并不大。但是他给人说了一个，我们临床过程当中望诊还是挺重要的。

这下面得出这个结论是实质性的，”两耳无所闻”，就说失聪，人听不见了。人本身这个出了汗以后就虚了，手都扶着胸前，再加上听不到东西，这病就够重的，因为发汗发得太过了，“虚故也”。这个“虚”呢，应该有两个方面去理解：一个是人虚，再一个就是津液虚，造成耳聋的这种情况。这个我们在临床当中虽然少见，实际见到的不多，可是这也是古人总结的一种经验，如果发汗发得太多了，还可能致人耳聋。

如果咱们细品一下这个条文，你不难发现，它的写作风格和顶格的条文，和降一字格的条文的作者的写作风格，明显有区别。总体来看降两字格的这些条文里面，也有好的条文也让人感觉很经典，但是不好的条文真是水平太低，差距太远。很难武断地给他做一些什么样的鉴别，也没那个必要，但是我们总是有这样的感觉。

上边是 75 条一，这儿是 75 条二。在《宋本》里边它们是同一条内容，《康平本》里边分开，我们现在学 75 条的第二段。

发汗后、饮水多必喘、以水灌之亦喘、（75）

这是两种不同的治疗方法。

“发汗后”，这一般是指的表证发汗以后，但是表没有完全解除的这么一种状态。这种状态如果让他饮水过多，他就会出现喘证。这个意思实际上在其他的条文里也有，“饮水多必喘”，你看第 71 条里面，它不就有这种情况，它等于说是对 71 条的一个进一步的论述。

第 71 条里边“太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，躁烦不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈”。这个地方如果不让他“少少饮之”会怎么样呢？这儿就跟你说如果听任这个患者随意地大量地

去饮水，他就有可能发生喘证。这个喘的机理，以我们今天出现这种情况的机会不多，但是要出现了以后，你得知道他是怎么回事儿。我刚才说一次性喝水多了以后，自己胃里很不舒服，也是这种体验。它说明了胃容纳的食物和水都有一定的限度，水和食物不管哪一样都不能无限得多，多到超出了一定的量，人体就是一种不良作用，是一种负担。这种情况下大量的饮水，在胃里停着，一时消化不了，胃体积相对就大，这个时候他表证刚过去，如果出现这种情况，这个胃就会影响到它上方，它挤压横隔膜，会对肺的呼吸有所影响，就会出现喘证。但这个喘证相对地说还是比较短时间的，比较轻的。

后边这个就比较重，“以水灌之亦喘”，“以水灌之”，这是古代的一种治疗方法。咱们今天不是“以水灌之”，今天用酒精棉球去擦。人发热，为什么要以水灌呢？就说表证服了发汗药以后，发了汗了，但是烧没有退，体温没有降或者体温降得不彻底，这个时候他见体温不降就降点温吧，然后就用这种方法。大家看继承了多少年了，让人感觉到不可思议啊，古代用这种方法治疗，实际上这是错误的方法，一直到现在，现代医学还用这种方法。道理在哪儿？因为他看着体温高了，不能让它高得太厉害，就降降温吧，这种降温的办法不是去病的办法，是加病的办法。

第 141 条里面也有这样的论述，在经方里面认为这种治疗是错误的。“病在阳，应以汗解之，反以冷水濯之，若灌之，其热被劫，不得去，弥更益烦”。这个意思是什么？我们经常说就是淋浴，实际上是用水喷身，喷淋身上。“若灌之”，是用水洗、浇，就是我们这儿讨论的。

在经方里面，认为这种治疗，“热被劫不得去”，你治不好，它病更加重，“弥更亦烦”嘛。这个用水灌很可能在当时，是一种常见的外治的方法。但是在经方理论里边，认为这种方法是不可取的，是错误的。为什么会造成喘呢？道理非常简单，他本来就是一个表证，

你又发过汗，它又烧没退，这时候你就一下用冷水往身上一浇，大家想想，在冷水的这种刺激下，皮肤的这个汗腺呀一下就全部关闭了，关闭了以后皮肤的呼吸功能基本上就丧失了，它就近乎于表实证的那种情况。所以说这时候就会影响到呼吸系统，这个前面咱就说了不止一次。这个条文我想也应该是这个作者在临床当中实际总结出来的一些经验。

下面作个小结：太阳病发汗过多，如果患者因口渴而不加节制地饮水过多的话，则可能发生喘证。如果见热不得除，而误以冷水洗身的话，也可能造成喘证。

发汗后、水药不得入口、为逆·若更发汗、必吐下不止、发汗吐下后、虚烦不得眠、若剧者、必反复颠倒、心中懊憹、栀子豉汤主之、若少气者栀子甘草豉汤主之、若呕者栀子生姜豉汤主之、（76）

栀子豉汤方

栀子十四个擘 香豉四合绵囊

右二味、以水四升、先煮栀子得二升半、内豉、煮取一升半、去滓、分为二服、温进一服、得吐者、止后服、

栀子甘草豉汤方

栀子十四枚擘 甘草二两炙 香豉四合锦囊

右三味、以水四升、先煮栀子甘草、取二升半、内豉、煮取一升半、去滓、分二服、温进一服、得吐者止后服、

栀子生姜豉汤方

梔子十四个擘 生姜五两 香豉四合锦囊

右三味、以水四升、先煮梔子生姜、取二升半、内豉、煮取一升半、去滓分二服、温进一服、得吐者、止后服、

胡希恕：“发汗后，水药不得入口，为逆，若更发汗，必吐下不止”，这也是一条，以下另一条。这个说的水逆证，本来他是小便不利，那么里有停水的这种人，你发汗不行，那是误治。发汗后，那么就得五苓散的这种水逆证，微热、消渴，直门儿喝，他就“水药不得入口，为逆”，这个所谓逆者就是施治造成的，就是我们治疗给造成的逆证、逆治，由于逆治造成的，就是误发了里有停水人的（汗）这种病。这样你再发汗，越发汗表越不解，“若更发汗，必吐下不止”，你再发汗，激动这个里水，这个水不得出入，而上吐下泻不止，所以这个逆证啊只能用五苓散之类的办法，把水排出去就好了，你要再发汗，这个水上下而为上吐下泻这种病。在这是给五苓散作总结，五苓散这样很多，水逆到这个地方，只是用五苓散。在有五苓散这个水逆证更不可发汗，发汗能为上吐下泻这类的恶变，这个当医者不得不知。

底下这个他又另起炉灶了，另讲一个问题了，与上节是不相关的。底下讲的是虚烦这类的病。“发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒，心中懊侬，梔子豉汤主之；若少气者。梔子甘草豉汤主之。若呕者，梔子生姜豉汤主之”。他说也有这么一种病，在汗吐下之后，也发了汗了，也吃过吐药了，吃过下药了，那么这个人呢虚烦不得眠，这个虚烦不得眠不是真正虚了，虽然用过发汗、吐下药之后，他比原来还发烦，这个发烦不是有实证，也吃过吐药、下药，没有实质的证候，表也没有象我们说的麻黄汤那种表实证，也没有，这个虚就是指这个虚，不是一种实证的虚，可是这个拿着现在话说就是一种炎症，发汗吐下之后遗热不出，热在里头还有，那么这个人烦躁不得安眠，这个病很多呀，这种病一般说就是虚烦不得眠，要说厉害的话，必反

覆颠倒，心中懊憹。反覆颠倒就是睡不着觉，翻转不安啊，翻来覆去的，等他厉害的时候就是辗转反侧，不能安卧在床上，而心中懊憹，这个懊憹是烦躁剧烈的一个状态。这个懊憹，烦恼谓之懊憹，说这个烦躁，人啊不可名状，叫心中懊憹。那么这都是这个热冲击人的脑子，影响心脏的这种情况，才能发生一系列的毛病。

这都是热，在中医说是热毒啊，虽然吃过发汗、吐下的药了，但是这个热还不尽，拿着现在话说就是里头有炎症，那么这得用栀子豉汤。栀子豉汤这个药也是很常用的药，它是以解烦为主，解烦去热，不是真虚，真虚用不得苦寒药啊，象咱们说那个虚劳那个虚，用这个药不行。“若少气者”，所以这个热盛啊人气就短，内经说壮火食气嘛，那么这个少气也是呼吸短嘛，这个是一种急迫状态，并不是真正的虚，为什么搁甘草啊，就是这个热烦陷入急迫状态，呼吸短促，这个在栀子豉汤中加入甘草就行了，甘草缓急迫嘛。同时这个甘草啊，多少都有点补益性，但是在本草上没有这么说的，根据临床上的应用来看，它也多少有安中的意思，是甘药都有补益作用，甘药补脾胃。

“若呕者”，就是上边那个证候啊，我们还用栀子豉汤，但是要加生姜，生姜治呕。这个栀子豉汤啊就是栀子、香豉这两味药，这个药虽少，在临床上应用很多，凡是这个胸中啊说不上来的烦躁，大概都是栀子豉汤证较比多。这个方剂后面的注解有错误，他说是这两味药，“上二味，以水四升，先煮栀子得二升半；内豉，煮取一升半，去滓，分为二服，温进一服。得吐者，止后服”，这错的，这个栀子豉汤我常用，差不多用到这么大岁数，我一回也没遇到吐的，没有这个事，这个药不吐。这都是这个书注家这么搞的这个。

瓜蒂散这个药啊里面搁的豆豉，总是看瓜蒂散中有豆豉，栀子豉汤中也有豆豉，就寻思这个是吐药，不对的。这个豆豉是个什么东西？它是大豆做的东西了，那个东西不能使着人吐啊，根本也不使着人吐啊。这个瓜蒂散涌吐的作用也不在豆豉。这个就是不经临床，这个临

床试验，谁吃栀子豉汤吐啊，没有一个，哪有这个事呀。而且这一段，文章你们看看，他说发汗吐下后，你还给吃吐药啊，哪有这个事呀。这个本文，在发汗、吐下之后遗留下来的虚烦不得眠，你再给吃吐药，哪有这么治疗的？在这个文章上讲也不行。那么在这个方剂本身，通过实践，它也不吐。所以这个不是吐药。这个书流传时间比较长了，但是也没有给它更正，这个决不通。栀子甘草豉汤，就是栀子豉汤加二两甘草，也不吐，后面也是“温进一服。得吐者，止后服”，也是错的。后头这个栀子生姜豉汤更错，怎么说呢？栀子生姜豉汤本文明明这么说的，栀子生姜豉汤它治呕，好嘛这个方子还吐哇，这不是瞎闹嘛是不是。所以这个地方啊，讲书人怎么能在这个地方讲下去，我就纳闷。它治呕啊，怎么能吐啊，所以这是错的。这个我们不要信这句话。那么方剂好明白，这个栀子和豉全是解烦去热的药，消烦，去热，止烦。这个栀子豉汤是好药，在临床上最常用了，别看药少。后头的比较重要。

李冠杰：这个条文在《康平本》也是顶格的条文，除了条文中间“为逆”两个字是旁注内容以外，都是顶格的内容。

这个条文应该分成两段来解读。第一段就是从段首到“必吐下不止”这个地方，这是第一段；下边的内容是第二段。

我们先解读第一段。第一段论述的是什么？主要论述的就是对于里有停饮证的患者错误的施以汗法。如果客观地去想，医生之所以对这样的人投上发汗药，恐怕这个人有某些表证的表现。按照经方的治疗原则，只要有停饮，即使有表证，单纯用发汗的方式来解表肯定会造成一些不良后果。这个地方论述的也是误汗以后的一种不良后果。

发汗后出现什么样的不良后果？“水药不得入口”。实际上这就是对里有停饮的人，误用了发汗药以后加重了停饮的病情，实际上就是这么一个意思。那么他以前肯定不是“水药不得入口”这种情况，

吃了发汗药以后，按胡老的说法就是“激动里水”，实际上里饮这个病情加重了。那么“水药不得入口”，实际上就是前边所论述的那个“水入口则吐”的五苓散证，只是文字上稍微有点出入。

“为逆”，这两个字是旁注文字，他本身就是想说这是一种错误的治疗。但是这个注解纯属多余。大家想一想，如果这个人以前没有“水药不得入口”的这种情况，那么他服了发汗药以后，发生了“水药不得入口，入口则吐”。出现了这种情况如果还不算是误治的话，那就没有误治可言了。在这儿人家这个症状表现就已经说得很明白了，你在这儿再加上“这是误治”本身就是多余的，这两个字加的没有什么意义。但是有的注家解释这个“为逆”是指的“水逆证”的意思。前边不是有一个五苓散证，也就是“水入口则吐”，给它起了一个专门的名字叫作“水逆证”，实际上有点牵强了。为什么呢？因为“为逆”这两个字在其他的条文里边还有，那儿指的都是误治的意思，是错误的治疗。所以这个注解就是可有可无，实际上就是多余的。

下边“若更发汗、必吐下不止”。就是在上面论述的情况下，如果发现表证还没解，再给他吃发汗药的话，就可能造成“吐下不止”的严重后果。实际上这个“吐下不止”还是五苓散证。

这一段条文论述的重点就是，五苓散证有的时候是因为误汗而来。发生了五苓散证之后，如果再进一步地发汗，在临床当中也是一种经验，就有可能出现这种“吐下不止”的情况。这个“吐下不止”本身就是里饮证的一种重症。在病理上也不复杂，就是消化道内停饮太严重，以致于影响了消化道正常的内环境。

对于这样的情况，《伤寒论》里边有专门的论述。在霍乱篇第386条有“吐利，头痛发热（注解是霍乱），身疼痛”。说这样的病就是霍乱的一种。然后“热多欲饮水者，五苓散主之；寒多不饮水者，理中丸主之”。那儿说的“吐利”，后边还有“头痛、发热、身疼痛”，这不跟表证很相似嘛。实际上这个地方论述的基本上跟386条论述的

情况就非常接近。

那么在这种情况下，你要如果说再发汗的话，那就更了不得了，实际上就这么来的。

但是这种情况，在实际临床当中会经常见到：小儿的“上吐下泻”，好多都跟水饮有关。特别吐泻都是以“水”为主，里边没有明显的不消化的食物什么的，这一类的大部分都是水证。假设你在临床当中碰到这种情况，小儿腹泻是一个常见的症状，甚至有时候就上吐下泻。因为小孩子自己不会说，就靠医生的经验，你平时对这些东西了解得比较深入，就会遇事不慌，沉着应对。这里有一个需要警惕的问题，他如果是热性下利的话，五苓散也好，理中丸也好，都治不了。你得用葛根芩连汤，或者白头翁汤来治。但是他下利的情况跟这个截然不同，他大便里边就带了好多沫状的东西，甚至有胶冻的东西。寒性下利呢，大便里边有好多没有消化完的一些食物。另外脉象、舌象、舌苔上，这都可以佐证的，不能仅看一样。

有时候里虚寒证伴有水证出现的机会很多，这个时候用理中汤合上五苓散实际上是一个非常好的方子。

我以前在济南的时候，听说有一个老中医，他也不是中医，就是继承了他家传的这么一个秘方，就治这一个病，他也没有什么门诊，就在家里边，熟人或者口口相传，孩子腹泻就找到他，他就给你包一点药。实际上从他那个治疗上看，大概就是这一类的治疗理念。就是说既能治水又能温里。小孩子这一类的情况很多，基本上大多数的小孩都会出现，在一岁左右的时候往往要出现一次。因为这个时候呢，按他的生理来解释，孩子要断奶的时候，他的肠胃啊，有一个转型的阶段，实际上这是现代医学的一种解释。但是在临床当中，不一定所有的一岁左右儿童都会出现上吐下泻，或者说下利，也没有那么准确。但是，这是小儿多见的一个症状。假如说有表证的话，就用桂枝人参汤。实际说透了还是辨寒热、辨虚实、辨表里，大致上就是经方的这

些。这儿又加了一个辨水证，这就是经方的辨证过程。

这个条文论述到这儿，症状说得很明显，病因也说得很明显，但是没有给具体的治疗方案。实际上这类情况在其他条文里边已经都论述到了，所以在这个地方就简了，省略了。你看第 74 条，这个条文实际上是承接第 74 条之后的。大家再看看《康平本》的第 75 条是什么内容？咱们刚学过去。第 75 条是“未持脉时，病人叉手自冒心”。这条是王叔和加在这个地方的内容。如果把第 75 条抽出去，第 76 条不正好接着第 74 条上吗？实际上就是第 74 条进一步的论述。咱们再回顾下 74 条“中风发热，六七日不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入口吐者，五苓散主之”。这举的症状是“水药不得入口”，实际上是一回事。

这一段文字跟下边的文字，在内容上论述的不是相同的问题，我们就把这一段单独做一个小结：患者服发汗药后，出现水药不得入口的症状，是对里有停饮的人误施了汗法，如果见病不愈，更复以发汗法的话，则可能造成吐下不止的不良后果。实际上这个地方，则可能造成吐下不止的五苓散证更合适。

但是这一段文字在历代学习的过程当中，很多学者的理解都有些偏见。对上边这段文字我找了一个比较典型的解释，咱们看看这种解释，也就是把大家带到我们学习的环境之外，把眼光拓得宽一点，就看看别人在学这条的时候人家是怎么学的。我跟大家原文读下：“言发汗后水药不得入口，为误治之逆证，良由未汗之时，中气虚寒，纵然兼有表证，也只宜温中散寒兼以解表，若率用辛温发汗，必然发越已虚之阳，则虚损更重，卫阳即以不足，则阴寒之气盛而上逆，使受纳之所，拒而不受，故之为呕吐而水药不得入口，此时若误作太阳伤寒之呕逆，再发其汗，一误再误，必至中阳衰败，不唯呕吐，而且下利不止”。这是比较典型的一种理解，换句话说，这是大多数历代学者理解的一个总结，应该这么说。

凡是有一些经方理论知识的人都能听出来，这里边有一个很重要的问题，他认为这种情况的人不是里有停饮的人，而是里有虚寒证的人。对里有虚寒证的人误用了发汗法。在经方里面，里有虚寒证的人也不能单纯地发汗，这点也不错。但是再往下想，这一条已经误治了，又发汗以后病情更重了，应该用什么来治？按他的解释，在发汗之前应该用桂枝人参汤之类的方剂来治疗。发汗以后，人出现了水药不得入口，甚至又发汗，出现了上吐下泻的情况，按他的理论的话，那就应该用或理中汤或四逆汤来治。对不对？大家想想。

但是，按我们的理解的话，这应该用什么方剂来治？我们就把它假设成外有表证，里有饮证，这可能是一个小青龙汤证。小青龙汤证误用了单纯发汗的方法以后，出现了“水药不得入口”，又发汗，出现了上吐下泻。就应该用五苓散来治！大家想想，如果一个五苓散证，你用了理中汤或者说用了四逆汤，前边如果是小青龙汤证，你用了桂枝人参汤，大家想想能治得了吗？治不了的。

所以说，我很赞同这种说法：经方的历史就是一部误读史。到最后读到什么程度啊？大家都信，都把它捧为圣经，但是一个用的人也没有，就是说用的人少之又少。这是第一段。

下边呢，咱们再学习第二段。再读一下原文：“发汗吐下后、虚烦不得眠、若剧者、必反复颠倒、心中懊憹、栀子豉汤主之、若少气者栀子甘草豉汤主之、若呕者栀子生姜豉汤主之”

这一段文字，虽然和上一段文字是同一段内容，但是论述的不是相同的问题。那个论的是五苓散证，这个论述的是栀子豉汤类方证。

“发汗吐下后”，这儿把经方对那个“病因”的使用可以说是淋漓尽致，汗、吐、下都属于攻法。这儿说了这么一大堆，并不是说，一个具体的医生给一个具体的病人先用了汗法，又用了吐法，又用了下法，不是这个意思。他的意思就是说你屡用了攻法，或者也有可能连续地对一个患者用下法或者吐法，都有可能造成这种情况的。关键

就是给你说，屡用攻法，连续地用了攻法之后，攻法就会致人虚嘛！

“虚烦不得眠”，就是因为虚造成人出现了一种烦躁的症状，不能正常地进入睡眠状态。按照我们现在的说法就是失眠，或者神经衰弱这类的病。那么这个“虚烦”啊，就是一个病证名字。按照权威的解释：第一个呢，指的阴虚而致心胸烦热，就是我们学得这种情况；第二个呢，邪热所致的但发热而心烦者；第三个呢，状如伤寒，不恶寒，身不疼，头不痛，脉不紧数，只是热，这样的症也叫做虚烦。这一条里边这个烦，它是热所致的，不是里虚寒证造成的那种烦，像茯苓四逆汤那一类的，不是那一类的。

具体到栀子豉汤上这种虚烦，多是发生在人体胸部，偏于亢奋的虚热性的病变。按我们现在的说法，就是某种炎症造成的。那么什么叫虚烦呢？你看栀子豉汤证的这个虚烦，从性质上说是热性的，所以说跟虚寒性的，本质上就不一样。但是呢，跟承气汤类的里热和白虎汤之类的里热也不一样。除了疾病的部位不一样之外，虚实程度也不一样。承气汤之类的热纯属里实热，属实热证；白虎汤证就介乎于栀子豉汤证和承气汤证之间。白虎汤证要跟承气汤证比呢，在虚实这方面它为虚；但是跟栀子豉汤证比的话，它又为实，这点很重要。

山西李翰卿老中医说：我治病善于治夹杂证，而且我在治病过程当中，还善于分析不同类型的夹杂证各占的分量是多少。辨清这以后，才能做到用药丝丝入扣。我自己临床当中也有这种体会：你比如说，这个人既有麻杏石甘汤证，又有一点小柴胡证。如果麻杏石甘汤证重，小柴胡汤证有，但不是那么突出，你可以用麻杏石甘汤二小柴胡汤一，这样合到一块。如果你辨证对的话，它的疗效比单纯地服其中的任何一个方子都会好。

实际上在临床当中，虚热证还有一系列的，还有其他的佐证。你不能在这儿空谈栀子豉汤证跟白虎汤证两个差别多大？幅度多少多少。你有什么证据呢？有，都有。比如说啊，栀子豉汤证尽管是虚热，

它也是一派热象。纯栀子豉汤证的话，基本上是找不到寒象的。白虎汤证也是一派热象。可是栀子豉汤证的口渴与白虎汤证的口渴在程度上就会差很多。从舌象上脉象上这都不一样的。所以说在四诊的过程当中啊，不要只盯在一项上。

后边“若剧者，必反复颠倒”，就是如果严重了，会出现卧起不安、辗转反侧那么一种难以名状的难受。这就是虚热证而导致的烦躁症的重症。严重到什么程度啊？患者已经出现了坐坐不住、卧卧不住啊，就是坐起不安的这种程度。对这个栀子豉汤证的论述啊，很多人都会觉得我们没见过这样的病人，他到底是个什么样的情况？

咱就说说这个“反复颠倒”，我自己有过一次体会，就是栀子豉汤证。而且最后也是吃栀子豉汤好的。难受，难受到什么程度？说不出来，很难说出来的一种难受。刚躺下去觉得那个脑袋有一种空的感觉，就是整个脑袋就空了，在那躺不住，太难受了。就马上站起来，等坐起来以后又有一种难以名状的烦吧，也很难说，倒也不是说想发火着急，也不是说那种，就是说不出来的那种难受，到最后我就打坐吧，两个腿盘起来坐一会，慢慢地还会缓解一些。确实是很难用特别准确的字眼来形容。

下面一个症状就更明显了，“心中懊憹”，是栀子豉汤证非常典型的一个症状。这个“懊憹”要按中医的标准解释，指的是心胸烦热、闷满不宁之状。这个解释说给大家的时候，你还是说不清楚到底是一个什么样的表现，在我面前活生生的病人到底是什么样的表现呢？关于这个呀，有一个挺有意思的小事。北京中医学院有一个学生听刘渡舟讲伤寒论的时候，讲到这儿，这个学生很认真，也很较真，下了课以后啊，他就去问：刘老师这个心中懊恼到底是一个什么样的感觉？刘渡舟老师跟他解释啊，也非常有意思，我给你打个比方吧：就是喝了蒜泥以后的那种感觉，就是那种感觉。这个学生回去以后砸了一些蒜泥，然后喝下去，后来他说：我知道是什么感觉了。据说后来这个

学生也成为很好的医生。就是说这种认真的精神。

那么这一条讨论的病理呢，我觉得应该这样来给它定性，它是阳性的半表半里虚热证，还伴有轻度的里热，不纯是半表半里证，有轻度的里热。

这个栀子豉汤是一个类方，以栀子为主的。栀子豉汤所对的疾病，也是一个系列的疾病，以栀子豉汤证为基础。

这个方剂一共就两味药：栀子 14 个而且掰开，香豉是四合。其实我们现在临床当中大部分都是各半，就是说你用多少栀子就用多少香豉，一般这样用得比较多。那么这两味药都是去热解烦的药。其中栀子还有利小便、缓下和去黄的功能。香豉也去热、也解烦。

栀子豉汤方证：

症状：心烦、失眠、发热、纳呆、尿黄赤、恶心呕吐、胸中痞闷，口渴、便秘、脘腹胀满、头痛、面赤、胸胁痛、眩晕。

舌质：红舌为主，还有淡红舌、酱红舌。

舌苔：以黄苔为多，还有白苔、灰苔、黑苔。

脉象：数脉、弦脉、滑脉、浮脉。弦数脉、滑数脉、浮弦脉、浮滑脉。

有应用栀子豉汤机会的现代病：

流感、中暑、副伤寒、神经官能症、植物神经功能紊乱、癔病、感染性精神病，精神分裂症、病毒性心肌炎、心包炎、肺炎、急性肾炎、慢性肾炎、膀胱炎、食道炎、食道憩室、咽炎、扁桃体炎、腮腺炎、慢性胃炎、急性胃炎、胆囊炎、子宫功能性出血、牙龈出血、过敏性紫癜、黄疸。

几乎所有栀子类方剂后边都有这么一句话：“得吐者，止后服”。这个胡老也解释得很清楚了，这个说法不对。从刚才说的症状里就有一个症状，恶心呕吐，它治的症状里面就包括恶心呕吐。那么这个方剂还会致人吐吗？不会的！胡老就这样说：我用得多了，有的人成斤

地喝，也没有出现呕吐。我呢，也不止一次地喝过，从来就没感觉有呕吐。要如果对症以后还助消化，喝了以后一会儿还感觉有点饿。

再往下，就是“梔子甘草豉汤证”了。“若少气者，梔子甘草豉汤主之”。这个方证，就是在梔子豉汤证的基础上，又见短气的这类症状。

“少气”，这里有两种解释：一个是正常人体经脉中的血气构成比例，其气分偏少，这是内经里的说法；还有一个，言语无力、呼吸微弱、短促等症状。这个比较适用于我们学习的这种情况。

我们从临床资料上，用这个方剂的，就是有梔子豉汤证，但是身体趋于虚弱。实际上梔子豉汤，本身对的是虚证，是在误治了以后，在很短的时间内致人体虚的。以前的时候人体就比较虚弱的，用梔子甘草豉汤治疗的机会就比较多。也就是说在误治之前，这个人本来体质就比较弱，得了梔子豉汤证的话，有可能出现精神也不佳啊，一派虚弱的情况，呼吸比较短气，这样就用梔子甘草豉汤，比单纯用梔子豉汤要好一些。

那么方解，这个方剂就是在梔子豉汤的基础上，加一味炙甘草。就是补虚，缓急迫。

方证呢，就简单地总结一下：就是在梔子豉汤证的基础上，患者又有比较明显的虚弱、短气、乏力等这类的症状。

对应的现代病，跟梔子豉汤比较接近。梔子甘草豉汤也能治那些病，但是人体更虚的那种。

原文再往下，“若吐者，梔子生姜豉汤主之”。胡老在这里特别告诫大家要注意的，它本身就治吐，后面方剂还有“得吐者，止后服”，很没有道理。

这个方剂也是在梔子豉汤的基础上，又现恶心呕吐的这种，又有里虚的这种情况。

从病理上也是梔子豉汤证出现里虚或者是停饮或者偏于寒的这

一类的证候。按照我们现在的说法，就是栀子豉汤证又表现为虚寒性的胃功能的低下，胃功能不好。生姜的作用，就是温胃止呕。

下面我们就把整个三个方剂做一个小结：

发汗以后又施以吐下的方法，造成虚烦不得眠，如果严重的，则可以发生反复颠倒，心中懊憹，此为栀子豉汤主治之证；如果同时伴有少气的，为栀子甘草豉汤主治之证；如果同时伴有呕的，为栀子生姜豉汤主治之证。

发汗若下之、而烦热胸中窒者、栀子豉汤主之、（77）

胡希恕：无论是发汗，或下之，烦热，胸中窒，胸中就是当间，就是胸部中间，就指着食道说的了，人发烦热，感觉这个地方啊堵得慌，滞塞，这个病很多，你象食道上的食道炎啊，食道上的病很多是这种情形。我治一个食道憩室，他就是这么种病，我就给他吃栀子豉汤就好了，西医也是奇怪，中医就是辨证，他有这种证候，你用这种药是准行。我也不知道栀子豉汤还能治憩室，它之所以能治憩室，是因为憩室发生这种证，他就是心中懊憹，烦热，这块儿觉得滞塞，这个病最多，食道方面的病啊栀子豉汤证很多很多。这个胸中指着当间这一道啊，不是整个胸，整个胸那是柴胡证了，这个胸中就是指着食道说的，这个很要紧啊。也不吐，我们治食道憩室那个人啊，他吃了栀子豉汤那么多，有二斤，他也没吐过，他一天吃两遍，他越吃越好，他老吃，后来再拍片就没有憩室了。可是我们遇到这种病啊，象头前说这个，“发汗，若下之”之后，一般不会使郁热不除而产生这种病。假设不是发汗或下之，也有烦热，胸中窒，也可以用这个方子，不必非得发汗或下之之后。那么就是我们在临床上，不一定是发汗或下之之后见这种证候，就象方才说那个（患者），没吃过发汗药，也没下过，他就有这种证，你就用这个方子就行的。那么这个书呢（这个地

方)讲的是太阳病啊，太阳病当然讲发汗。他说发汗之后，又吃过泻药，他意思说呀不是实证，不是胃肠里头有实，也不是表不解那种实，这种烦热大致都是咱们说的这种炎性的这种证候，所以搁个虚烦。

李冠杰：这条是顶格排版的条文。

下边解读一下：

“发汗若下之”。这一条论述的是栀子豉汤的另一类比较典型、比较特殊的一种表现形式，实际在临床中并不一定是经过何种误治，比较容易能够碰到这一类的病人。条文里边之所以说经过发汗或者吐下后，我们应该这么理解：发了汗以后如果再下的话，出现这种方证的可能性要大一些。所以古人把它作为实例列在这个地方。

“烦热胸中窒”，这是一个典型的症状。“烦热”前边学的已经都有了，虚热而且烦躁。这里边已经包括了栀子豉汤前边已经论述过了烦躁不安的情况。关键是“胸中窒”，这个“窒”是一个很特殊的症状，而且是栀子豉汤证里边多见的一个症状。这个“胸中”就是指的胸部中间部位，“窒”就是指的滞涩，阻塞不通的意思。这个“窒”还有另外一个意思，尽管稍微远一点，拿过来可以帮助理解，它本身有障碍物的这么一层含义，滞涩而且还类似障碍物的感觉。大家去体验一下，后边这个就比较好理解了。“胸中窒”就是患者感觉胸部中间的位置有阻涩不通的这种感觉，好像有什么东西在里边挡着一样。咱们再往下学，挺有意思。“烦热”与“胸中窒”同时出现，尽管“烦热”，又表现得烦躁不安，有烦热又胸中阻塞不通这样的感觉，这是栀子豉汤证的又一种表现。那么，这是什么病呢？我们刚才在读栀子豉汤证所对应的现代病里边，有这么几个病：一个是食道炎，再一个就是食道憩室，甚至有某些食道癌这一类的患者，就常有类似这样的反应。用这个方剂治疗，可以常常起到非常好的疗效。

栀子豉汤在《伤寒论》里边，对它论述的条文挺多，而且用它延伸出来的方剂相对说也不少。它还有一个很重要的特点，栀子、香豉

这两味药在其他的方剂里应用的频率就不高，几乎是它们自己一个体系。换句话说，这一类方剂所治疗的疾病，如果用其他的方剂来治，疗效肯定要打很大的折扣，恐怕很难取得满意的疗效。但要是栀子豉汤证，用它疗效就非常好。

我们在深入一点看看，拿一个典型的食道憩室，我们做一个简单的分析。现代医学对食道憩室的研究认为，食道憩室是人体食管壁的一层或者是全层局部性膨出，形成与食管腔相通的覆盖有上皮的盲囊（就是盲袋），其发病原因多是因该处的淋巴结炎症或是淋巴结感染后，与附近的食道壁发生黏连和疤痕收缩所致。这是真性的食道憩室的一种解释；下边一种，或者是因食管内外有压力差，或者说食管粘膜经肌层的薄弱点疝出而成，这个是假性的食道憩室。目前现代医学对这种疾病的治疗，只有采用手术的办法。一种是因为食道附近的淋巴结发炎或者说感染了，结核性感染，造成食道壁里边（我们把食道想象成一个管道）有东西膨出，实际上就是管道里边鼓出一个疙瘩。吃东西时这个疙瘩就起到阻碍的作用，甚至严重的还把食物堵住了，吃进去的东西就停在食道里边，食道就像鸡的嗓子一样，形成那么一种东西，就叫憩室。憩室嘛，食物在这个地方休息的一下的场所。这是一种。另外一种就是食管管内外压力差，内外压力差每个人都应该有的。但是有的人就出现这种情况，造成经肌层薄弱的那个地方疝出，实际上也是鼓出一个疙瘩来，但是这个没有食道附近淋巴结的病变。就把它归结为食管管内有内外压力差形成的这样。现代医学对这种病没有办法，做手术那还叫办法吗？做手术是没有办法的办法。大家仔细想，首先说淋巴结发炎造成的，给这个淋巴结消炎，消炎不是现代医学的强项吗？抗生素消炎能解决吗？又解决不了。解决了就不会做手术了。这不是真正的原因，是仅仅看到的原因。另一种的原因就更不是原因了，食管内的压力差每个人都有的，为什么偏偏这个患者有这个疝出的症状？也解释不了这个原因。

我们中医如果站在这个意义上从微观的解释上来说，没有任何能力去解释它。但是我们掌握了能治疗它的办法。根据药性我们知道这是一个什么病呢？中医对这个方证总结的很好，这叫“热扰胸膈”，就是胸部这个地方有热，是造成这种疾病的一个真正的原因。

在这点上，我跟大家说得稍远一些，把这个思路再推广一下。抛开这个病再去看看别的病，比如糖尿病，现代医学先从症状三多一少，然后研究到了尿糖指标高后，血糖指标高，胰腺分泌水平低，然后胰岛素分泌水平低，胰腺功能不好，这是现代医学整个研究的一条路。就知道胰腺功能不好。为什么胰腺功能不好？不知道。要等多少年以后才能把它的病因弄清。现在治疗的办法就是补充胰岛素，你的单位水平不是低了吗，给你补充胰岛素，补充了胰岛素，患者自身分泌胰岛素的功能自然就退缩了，因为外界往里补充胰岛素，自身生成胰岛素的功能就会相对降低。自身的生成的能力降低怎么办？不知道！我们也不知道为什么他胰岛功能不好，但是现在找到了一种办法，补充了胰岛素病人感觉确实好，那个尿糖指标确实可以控制住，甚至降下来，这不就很好了吗！对，前提是就这样了。但是我们再深入理解，假设三十年、五十年以后，已弄清了是什么造成了分泌胰岛功能不好，那到时候就会出现新的治疗办法，这个补充胰岛素的做法肯定会被淘汰，或许到那个时候就会明文规定绝对禁止使用。为什么呢？至少它降低了人类自身产生胰岛素的功能。

我们再倒过来想，今天用补充胰岛素来治疗的人，他本身用的就是一个不完美的办法。对不对？中医治这种病，三多一少的，大部分用白虎加人参汤，这个方剂在三千年以前就是治这种病的，现在还是它治这种病最好，再过多少年以后还是，不存在落后的问题，这就是最佳治疗方法。再推而广之，这就是中医和现代医学很重要的一个区别点吧，没必要说太深了。但食道憩室这种病，现代医学做手术治，弄一个类似于气球的东西，在食道里插进去，病人很难受的，然后插

进去那个憩室的（憩室不是一个带状的东西嘛，等于说有一个上口，上口再往上是口腔食道了，再往下就是胃，胃有一个下口），把那个东西弄到下口以后往里充气，充气以后那个胶囊一膨胀，然后把那个地方撑开。以后一次一次地撑，一次撑上几下，休息一段时间再去做第二次手术。撑来撑去，这个地方就慢慢下去了。大家想想，这叫治病吗？按照现代医学的解释是淋巴结发了炎造成这种情况，用气球去撑这个淋巴结发炎能好吗？大家心里面都心知肚明的，都很清楚，不要去细讨论了。不是单纯这一个病的问题，这事儿深入去想让人感觉很不舒服。

伤寒五六日、大下之后、身热不去、心中结痛者、未欲解也、栀子豉汤主之、（78）

胡希恕：这也是给治错了，伤寒没有给吃泻药的，五六日表不解，还得解表啊。这个“大下”，下就错了，大下就更错了，这时就指着邪陷于里了，热邪被陷，所以身热不去。“心中结痛者”，这个心中不是指着心下，大概这个可能指着心脏，他这个书啊是指着心中的这个话，都是指着心脏这个部位。“心中结痛”，心中有支结疼痛的感觉。那么这个病我是没遇到过，据我的体会呀，可能类似心包炎的这类的病，由于这个表热，他吃泻药，使邪热内陷，影响到心包发炎，可能是这种情况。心中结痛啊，“未欲解也”，说这个不是好病的样子了，不是要好了，这个可以用栀子豉汤。但是我用栀子豉汤治这个急性心包炎的时候，我治过，是有效用的，但我不是只用的栀子豉汤，我配合旁的药物。那么根据这段象心包炎的这种情况，我也不敢说，因为古人没有明说呀，不过我们这么研究的。他写的心中，不是心下，不是胃。

李冠杰：这是栀子豉汤证的另一个表现形式，这也是一个顶格的

条文。

下面解读一下：

“伤寒五六日”，太阳表实证已经多日了，病程比较长了。这儿要给我们传送一个什么信息呢？他义言外之意就是人体的正气已经有所损耗了。

“大下之后”，本身人的正气就已经有所损耗了，你又大下，本来这个表证就应该用麻黄汤之类的发汗方剂发汗解表。下本身就是错误的，具体到这儿还是一个“大下”，用了比较峻猛的泻下的方剂。人的正气已经损耗了，再用峻猛的泻下的方剂，他必然会发生不良的后果。具体看一看治疗方剂，栀子豉汤，栀子豉汤是一个寒性的药，是去热的药。表证经过大下以后，反倒出现了热证，那么我们就有理由相信，还有表证“大下”以后，出现寒证的。出现寒证，用四逆汤来治，这个后边条文里都有。出现热证也是有原因的，这个地方所说的“大下”，恐怕就是指的巴豆之类的热性的泻下药。假设按照条文例举的这些条件我们分析的话，不是机械地理解条文，而是通过对这个的分析，我们去理解经方给我们展示了一个什么样的病理。原来是个太阳表实证，太阳表实证是个什么样的疾病呢？既没有明显的里热，也没有明显的里寒，就是没有明显的里证，也不应该有明显的半表半里证，如果有的话，这样误治就了不得了，这就是单纯的表证，没有其他的病，你让他吃了泻下的药，反倒是形成了肠道里，包括半表半里这一层，形成了一种热证。大家想想，如果用调胃承气汤，调胃承气汤三味药没有一味是热药，就甘草还是一个中性的药，或者小承气汤也根本不可能形成热证，大承气汤就更不可能形成热证了，那全是去热的药。吃那类的药，只可能形成虚寒证。通过大下以后反倒人出现热证了，它就应该是热性的泻下药，像巴豆剂这一类热性的泻下药。

“身热不去”，这话非常有分寸，挺有意思啊。为什么说“身热

不去”啊？他以前就是伤寒，就是表实证，表实证有个典型的症状就是发热嘛。那你短时间内用了峻猛的泻下药以后，这个体温还没有下去，身热没见缓解的样子。但是这个时候的身热和原来的身热就不一样了，这个时候的身热已经不是太阳表实证的身热了，这个时候人体通过大下，已经脱离了表证的病理阶段了。人体已经没有能力在表层与疾病作斗争了，已经转到半表半里和里，更深的层面和疾病作斗争。人体呈现一种亢奋状态，亢奋状态就产生比较多的热量，也会表现为体温高。所以这儿挺有意思，“身热不去”，就说身热本身应该去的，但是没有去，转手就转成里热证了。

“心中结痛”，指的胸部中间这附近的位置呈现出一种结节性的疼痛，这是一种病人的自觉症状。如果我们用现代疾病把它对照一下的话，大概就是心包炎、心肌炎。整个病理过程就是表证误下以后，人处于一种虚的状态，这个时候具体到出现这个方证的人体的胸部，也就是说半表半里这一层（具体到这一条里边就不是半表半里这一层）尤其虚弱。再具体到这一条所论述的症状呢，这个人心脏附近的组织机能尤其不好，比其他地方更弱一些。由于人体内环境的变化，首先从这个地方发生炎症一类的病变。病人主观上就感觉到心中有结节性疼痛的感觉。说到这儿，我们简单回顾一下栀子豉汤，栀子豉汤对应的好多症状主要都表现在胸部，你看总结的那个“热扰胸膈”，也是非常有条理的，比如“心中懊恼”，胸中滞涩，这条里边的“心中结痛”，都集中在胸部，但是表现形式各有不同。特别是栀子豉汤对应的这些方证跟其他的，比如胸痹证里边，胸前胸后感觉都痛，那是另外一种疼法，跟栀子豉汤就没有关系了，那是栝楼、薤白那一类的药所主的症状。栀子豉汤所主的症状，让人感觉它既不是很明显的很剧烈的疼痛，也不是一种让人烦的到精神崩溃的，没有那种程度，但是又特别难受，难以用语言表达的那种情况。刚才说的这几种都是用了比较不常用的一些字眼，“心中懊恼”、“胸中窒”、“心中结

痛”，跟其他的都不一样。这个我们在临床当中要注意去体悟，注意去倾听患者的自诉，从中去感觉这个方证和其他方证的不同点。

“未欲解也，栀子豉汤主之”，上边论述的情况不是疾病要痊愈的样子，他是发生了栀子豉汤证，要用栀子豉汤来治疗。

下边我们对这个条文作个小结：患太阳表实证已五六天的时间，医者却以泻下峻剂给予治疗，结果出现身热不去，心中结痛的症状，这并不是疾病欲愈的证候，而是栀子豉汤主治之证。

伤寒下后、心烦腹满、卧起不安者、栀子厚朴汤主之、

(79)

栀子十四个擘 厚朴四两去皮 枳实四枚浸水炙令黄

右三味、以水三升半、煮取一升半、去滓、分二服、温进一服、得吐者、止后服、

胡希恕：这个病也很多，同是误下，使着表热内陷的一种病。“心烦腹满”，心烦就是上面虚烦的这种状态了，厉害了也心中懊憹，而且腹胀满，卧起不安。卧起不安就说明心中懊憹的这么一种状态，剧者必反覆颠倒，他不能安卧嘛，起来，趴下，起来，趴下，就这样。那么这个用栀子以解烦热，用厚朴、枳实以去胀满。这个病也很多，这是这个病在心烦的时候，抑止了肠胃的这种情况。这个就是栀子加上厚朴、枳实这两味药，我方才说了栀子去烦躁，卧起不安，厚朴、枳实去胀满。这个卧起不安有两种原因，一种是因为胀的，另一种是热烦，两种原因搁到一起更使他卧起不安。

李冠杰：

这个条文在《康平本》里边也是顶格排版的条文。

下边咱们解读一下：

“伤寒下后”，跟上一条比较接近，本来是表实证，应该发汗解表，反倒是用了泻下的方法，就出现变证了。

那么，这一次出现了什么样的变证啊？“心烦腹满”，这个“心烦”，就是栀子豉汤证，换句话说就说栀子证。可能存在着某些栀子豉汤证的具体的症状，比如感到滞涩，或者心中懊恼。“腹满”，就是指的腹部有胀满的感觉。但是这个条文里边，要结合方剂的话，这儿论述的腹满，不是实满。因为表证误下以后造成的里虚，里虚以后，胃肠功能不好，反倒发生了气滞，就跟前边学过的厚朴生姜半夏甘草人参汤一样的道理。因为功能上的虚，造成了物质上的实。里虚可以出现若干种不良状态，比如热利的白头翁汤证、葛根芩连汤证，尽管是热性的，作为寒热之间比较的话，热性比寒性要偏于亢奋，但是具体到这个证呢，出现下利了，从物质上说反倒是一种虚。没有停滞到什么东西，反倒是少了，就是不及、不足，也就说反倒是形成了一种虚。那么这个地方出现了气滞，产生了好多气体，闹的人肚子里边满是气。这就是气滞证，气滞证也就是气证里边的一种实证，不是虚证。这个方证的腹满跟厚朴生姜半夏甘草人参汤相比的话，又有区别，因为这里边有枳实，有一定的食物的积滞，但主要的还是气。如果你要看病历啊，看医案什么的，这样的病人腹部明显都大，要是敲的话也砰砰作响。

“卧起不安”，本身“卧起不安”不难理解。但是“卧起不安”的原因，在病理上应该是：一个是有栀子豉汤证的烦，烦得厉害的时候不是反复颠倒嘛？反复颠倒本身就和卧起不安差不多，这是一方面的原因；另一方面的原因，就是腹中气滞造成腹胀满，特别是腹胀满得厉害，躺在那个地方腹部就更难受；起来的时候也不好受，但是躺着的时候就更难受。实际上这个病要从病理上说，也是半表半里的虚热证伴有气滞证。

我们作一个小结：伤寒误用泻下的方法治疗后，病人出现心烦腹

满，卧起不安的，为栀子厚朴汤主治之证。

这个方剂一共三味药：栀子 14 个，厚朴 4 两，枳实 4 枚。栀子就是解热去烦；厚朴枳实就是行气，消胀，治腹满。

那么在这儿，跟大家找了一个医案。一女性病人，心烦懊恼，昼轻夜重，夜间常跑的野外空旷之处，方才感觉舒服（就说心烦到了一定程度），并有脘腹气胀如有物阻塞之感，脉弦数，苔黄腻，边红，根部苔黄，大便尚可。辨为胸膈火郁，胃脘不和之证，主用本方治疗取效。

伤寒、医以丸药、大下之、身热不去、微烦者、栀子干姜汤主之、（80）大下之后、复发汗、亡津·小便不利者^①、勿治之、得小便利必自愈、（59）下之后、复发汗、必振寒脉微细、（注）所以然者·以内外俱虚故也·（60）（经）下之后、发汗^②、昼日烦躁不得眠、夜而安静、不呕不渴、无表证、脉沉微、身无大热者、干姜附子汤主之、（61）

注：

1. “亡津·小便不利者”《宋本》作“小便不利者，亡津液故也”。
2. “发汗”《宋本》作“复发汗”。

栀子干姜汤方^①

注：《宋本》无此方名。

栀子十四个擘 干姜一两^①

注：“干姜一两”《宋本》作“干姜二两”。

右二味、以水三升半、煮取一升半、去滓、分二服、温进一服、得吐者止后服、

凡用栀子汤、病人旧微溏者、不可与服之、（81）

干姜附子汤方^①

注：《宋本》无此方名。

干姜一两 附子一枚生^①去皮切八片

注：“生”《宋本》作“生用”。

右二味、以水三升、煮取一升、去滓、顿服、

注：此处《康平本》与《宋本》在条文的位置上有较大的差异，《宋本》中第 59、60、61 条三条文在《康平本》为第 80 条内容中的一部分。而干姜附子汤方位于第 81 条之后，可见第 81 条在《康平本》中为栀子干姜汤方后注的附注内容。

胡希恕：第 80 条：这个大下呀，古人这个大下就是指巴豆剂。这个巴豆剂古人常用的，究其实是个好药，但是巴豆剂呢是一个下寒的（方剂），它是个热药。所以经过大下之后，身热不去，药用的不对，不应该用这个热药来去热，热还是不能去的。

“微烦者”，这搁个微烦，这个烦是栀子证，但是这里头搁个“微烦”这两个字就是暗含着有“干姜（证）”这种寒证。这个病由于这个大下呀，这也是误治了，寒热错综，所以既用栀子，又用干姜。那么栀子证是烦得最厉害了，他搁个微烦，当然这里头有干姜，由于大

下伤中气了，伤胃了，同时寒也生了，这个方剂里头，在这一段里头没明白地说明，恐怕这个人有下利、呕逆这种情况，要不他搁干姜干什么？所以这个热烦也不太明显，但是还有，所以他用栀子、干姜，寒热并用，两个药，那么这个方剂呢，既有栀子证，又有干姜证。这个干姜证我们知道了，呕逆呀，胃虚有寒呀，或者有下利，这个干姜都可以治疗的。那么栀子呢，当然就治烦，烦热。所以经过误治之后，寒热错综，那么这个药也是寒热并用，这是不相悖。现在有人说呀你看你既用栀子，又用干姜，这没关系的，他只要有这种证，你这么用就不会错误的。他没有干姜证，你当然不能用干姜，没有栀子证，你不能用栀子。

这个段落呀都说得太简单，不够清楚，那么这个道理呢，他讲的是太阳篇，象这个方剂呀，你象干姜附子这类的方剂在三阴篇都有详细的说明的，在这里就本段，他说栀子是一个苦寒药，但是要有寒热错综的话呀，也可以与温性药配伍，意思不过如此。

李冠杰：这一条跟《宋本》的条文的位置发生了一些变化。这个条文第 80 条之后的这些内容，分成了三条，分别对应的是《宋本》的第 59 条、第 60 条和第 61 条。

下边咱们解读一下：

从文字的内容上看，整个这一大段条文论述的都是太阳病。特别是当这一大段放到一块儿的时候，就会发现那个“伤寒”，实际上是整个这四条共同的一个帽子。都是在伤寒的基础上经过了或下或汗的这样一种误治，但是由于人体之间的差异，或者由于具体治疗方剂或者治疗过程当中的一些因素的不同，就出现了各自不同的后果。这儿呢，他所真正要告诉大家的：类似的或者相同的误治，发生在不同的人身上，或者护理的方式不同，出现的变证都不一样。真正想说就是这么一个意思。他在叙述这个意思的同时，以这个为一条线，在这条线上他又附带了很多的其他的内容。遇到这种情况应该怎么处理，顺

便说了治疗的方法。

再进一步分析这个治疗方法呢，如果不是误治造成的这种病，你也能用这个方子来治。他用非常少的文字表达了很多的信息，关键是能够正确理解。

这个条目论述的确确实就是四种不同的情况，《宋本》条目的划分也是按照这四种情况分开的。我们按照《康平本》来学，在学完第 80 条以后，再去学第 59、60、61 条。这样学有这样学的道理，咱们学完了就知道了。

咱们先学第 80 条：

伤寒、医以丸药、大下之、身热不去、微烦者、栀子干姜汤主之、
(80)

这儿“伤寒”，指的就是太阳表实证。如果你想理解得宽泛一点也没有关系，理解成整个太阳病也行。

“医以丸药、大下之”，太阳病“下之”本身就是误治，这儿“大下之”，误治就更严重了。直接的后果肯定会致人更虚。这里说的“丸药”，指的具有猛烈的，比较峻猛的一个泻下剂。到底是什么方剂？我们现在就很难准确的给它定一下性。胡老在讲座里边讲这是巴豆剂之类的。但是巴豆剂之类的，这里边也有一个小问题，巴豆剂是一个热性的泻下的药，这一条所列举的方证，服了这种泻下药以后出现了热证，恐怕是那个药的可能性比较大，但是后边还有其他的。其实，我们也不一定非得去弄得很具体了，就知道是一个大下的方剂就行了。但是细推敲的话，栀子干姜汤有里寒的问题，它有半表半里的虚热，但是也有里寒。是不是吃巴豆剂会有可能造成里寒？现在不好给它很明确的定性。

“身热不去”，在这儿就已经不是表不解的身热了。因为过度的误下之后，导致人体进一步发展为半表半里有热，这个热的性质已经变了，这个时候已经没有表证了，从治疗方剂我们能看出来。

“微烦者”，这个地方的“烦”肯定指的是栀子证。但是“微烦”，也就是说烦的程度不是很重，是栀子证的一个较轻的症状。这个“轻”仅仅说栀子证的症状反应的程度不是很重。为什么呢？因为他同时有里虚寒这个因素存在。人体是一个整体，都是互相影响的，里有了虚寒证，半表半里的虚热证就不会表现得像栀子豉汤证那么严重，造成人烦躁得都不能睡觉了，恐怕程度就没有那么严重，它有一定的抑制作用。

从方剂的药物组成，明显能看出来这一条所论述的就是太阳病经过误下之后，出现了半表半里的虚热证，同时伴有里虚寒证这么一个错杂的情况。所以药物也是寒热并用，栀子为寒药，干姜就是热药。这里边还有一个问题我们必须得注意，因为这涉及到不仅仅是一个正确理解经方的问题，还有一个就是后人加的内容里边，我们去辨别真伪的问题。前边“医以丸药大下之”，然后用的治疗方剂却是一个寒热并用的治疗方剂。这说明什么呀？刚才我们说了，他同时伴有里虚寒。里虚寒的症状是什么？就是还有下利未止的症状。因为后面有方剂，条文里边就没有明说。恰恰是没有明说，所以对这一条的理解，历史上许多人都理解错了，包括王叔和。咱们不仅仅是从条文之间和药物上这么推，后边临床统计资料也能证实这一点。它所治疗的疾病里边，有下利这个证。

而且这个方剂我自己就用过，那段时间有一点儿虚热，有点栀子豉汤证，我因为肠胃的原因，肠胃长期以来就偏于虚寒，大便不太好，吃了以后很舒服，自己感觉啊，它有健胃的功能。栀子其他的方剂，大都是栀子豉汤证的基础上，加上生姜或者甘草。但是唯独这个方子，把香豉给去掉了。如果用栀子豉汤再加上干姜怎么样呢？那你吃了就不舒服！这是我自己的亲身体会，吃了以后就没有栀子和干姜两味药这么舒服。而且我不是不同的时期吃的，就是今天、明天这么一个间隔，二十几个小时的样子。所以说古人这方剂组成都是来自临床，经

过多少次试验了，有一些东西不能随便动的。

下边作个小结：太阳表证，医生误以丸药大力泻下，造成身热不去，并且微烦的，为栀子干姜汤主治之证。

这个方剂就两味药，栀子 14 个，干姜《康平本》是一两，《宋本》是二两。在这个剂量上象这一类的差错啊，别的地方还有，尽管不多吧，还有。在临床当中用呢，也不一定非得把它看得很死了。象这一类的情况，你在临床当中去辨病人反倒是比较好的，他要是腹泻比较严重的时候，干姜就多用一点儿，如果仅仅大便偏溏、热象非常明显的话，那就栀子用得更多一点儿。这两味药在这个方剂当中，栀子去热解烦，用来治疗半表半里的虚热证，干姜温中补虚，用来治疗里虚寒证。

这个方剂由于王叔和加的条文给造成了极大的误导，真正会用的就很少，用对了恐怕也有限。所以，统计到的医案就几个医案。

症状出现的频率最高的是：心烦、胃脘痛、口苦、呕逆、腹胀痛。出现频率比较低的：胃脘有灼热感或者呕吐、口干，或者是身热、腹部有时候感觉恶风寒、大便溏或者说泻泄。

舌质：淡、红。

舌苔：黄苔多见。

脉像：沉脉，弦数的脉。

顺便给大家说一句，这是在临床当中，我试过。症状里边有一个胃脘有灼热感，胃脘有灼热感是什么？日常生活当中的说法就是烧心，栀子类方确实能够治疗烧心。但是呢，不是碰到烧心的人就用这个方剂，你也要去辨。调胃承气汤也能治疗烧心。这两个从病理上说，是一虚一实，从症状上也会有区别的。调胃承气汤证仅仅是感觉到胃里边不太舒服。但是栀子类方证很容易出现胃的上部一直延伸到食道甚至胸部也会有类似灼热感，或者胸中懊憹，或者胸中窒，会伴有这一类的情况。如果有这种情况的话，你再仔细去辨，栀子类的方剂里

边哪一个比较合适，这就好辨了。不然的话啊，就这两个方证如果用反了，那疗效也不好。

有用到这个方剂机会的现代疾病：急性胃炎、慢性胃肠炎、食道炎、心肌炎、肋间神经炎、慢性痢疾、胆囊炎、胆石症急性发作、胆道蛔虫感染。

需要跟大家说明个问题，你看治疗的现代病里边啊，实际上比我刚才说的统计资料的医案还多呢。这是一个什么道理呢？我是从好几个资料上凑起来的，因为这个书上有这种病的记载，那个书上有那种病的记载，这个资料会更全一些。

第 59 条：

胡希恕：大下之后，吃的这个重下剂了，尤其巴豆这类的下剂，病不好而复发汗，这有这样的大夫吗？这个汗下倒置啊，一般都是有表证先解表，表解再治里。没有这个先治里，大泻之后还有表证的，很少了，就有表证也不能再发汗，那个发汗起码也是要用这个解肌这类的药物，像桂枝汤这类的，不能再用麻黄汤，他这个说的是用麻黄汤。那么这个汗下倒置，这种治疗啊没有不亡津液亡血液的，那么津液亡失太多了，小便也就没有了，所以这个小便不利是由于亡津液的结果呀。

这是误治，这就告诉你呀不要利小便了，所以在临床上不能见一个症状就治一个症状。我们遇到小便不利，当然要利小便，可是由于亡失体液造成的这个结果小便不利，他没有水分，你如果治疗反倒为逆了，所以他说是“勿治”，千万不要再利小便了。“得小便利，必自愈”，他由于津液恢复，小便自然利的。这一节就是承着上节说的，就是阴阳自和，表没有什么病，里没有什么病，只是由于这个大下、复发汗，体液亡失太多了，造成这么一种情况，没有其他的关系，这个你不要瞅着小便不利就治，他根据这个阴阳自和，小便不利也是一个不和呀？这个不和没有关系，还算自和之内的，所以这个不要治，

他这个津液会恢复的。如果不恢复怎么办？当然也要治，治你不要利小便了。

这个 59 条以下全是汗下失法，而造成种种的疾病变化。大伙要注意，桂枝汤、麻黄汤、葛根汤、大青龙汤、小青龙汤，这几个是顶主要的，那么另外有一些合方、加减方，桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤，这是合方。另外呢有桂枝加葛根汤、桂枝加附子汤，那么这些都是一些加味的方子，桂枝去芍药汤，都是加减的方子。那么回头这些主要方子在脑子里头得有个体会，因为桂枝汤它是解肌，它既能够亢进胃气而生津液，他这里头甘温嘛，这个胃是喜甘、喜温、恶寒、恶湿的这么一个脏器，所以桂枝汤这个甘温能够亢进胃气而生津液，它是这么一种发汗药，所以我们用桂枝汤啊必须以津液丧失为先决条件，你像我们头前讲的这个开始有这个表证，有自汗的需要用桂枝汤，不能用麻黄汤，自汗者就丧失体液，我上面给引征内经那一段，阴阳交，本来这个表证就是人体利用这个精气，想达到出汗的目的把这个病邪驱除出去，就是这么一种病机，我们根据这个症状分析也是这样的，可这个桂枝汤证出了汗了而病不好，足证他这个精气呀力量不足，无论在质还是在量上，他不足以驱邪，所以虽然汗出而病不愈，但是他不到阴阳交那么一个严重的状态，他能吃，没到那个不能食，所以他不要紧，但是我们治疗啊不能用麻黄汤，必须用养津养液的桂枝汤，这是桂枝汤。这个麻黄汤呢你看正相反，麻黄汤治表实证，由于表实，体液一点也排泄不出去，那么压迫人身上哪儿都疼，头、项、关节、腰，无处不疼，桂枝汤也疼，他比桂枝汤严重得多。同时，由于表气一点也不解呀，必波及到肺，他要喘，所以这是麻黄汤与桂枝汤的区别。这两个方剂在太阳篇里最主要。你看葛根汤，里头既有桂枝汤，又有麻黄，所以葛根汤（证）一定恶风，因为有桂枝汤的关系，他也恶寒特别厉害，他有麻黄汤的关系。所以葛根汤这个方剂是一个清凉性、滋润性的一种解表、解肌，解肌

是有桂枝汤的问题了，同时葛根这味药也解肌，那么主要的是项背强几几。太阳病也头项强，但是背不强，所以葛根汤能治痉病，如果这个项背强的程度达到一定程度，这个人就要抽，叫痉病，这个葛根汤也治，那是刚痉了，在《金匱要略》里有的。这个方剂呀在临床上是最常用的，凡是表不解，没有汗，恶风寒得厉害，觉得怕冷得厉害，无论他项背强几几还是不项背强，都可以用葛根汤。第四个就是大青龙汤了，大青龙汤是越婢汤与麻黄汤的合方，他这个方剂就是不汗出而烦躁，要不怎么咱们方才讲那个二阳并病，当汗不汗，其人躁烦，我怎么说是个大青龙汤证呢？就因为这一点。本来应该出汗，而汗不得出，这个人就烦躁，这是大青龙汤证。大青龙汤是大发汗药，麻黄用 6 钱啊，恶寒也相当的凶。大青龙汤与葛根汤这两个方剂的主证啊，全是表实无汗，而恶寒较比严重，可是这两个好辨，一个有石膏，这是大青龙汤证，必烦躁，或者口舌干，他有内热，这葛根汤没有。葛根汤有项背强，大青龙汤没有。这两个方剂啊全是恶寒比较厉害。这个小青龙汤证就是咱们平时所说那个外有风邪、内有痰饮的病，心下水气，表不解嘛。那么这个方剂偏于温，它有干姜、细辛、五味子这些药，他有咳喘，咱们说这个痰饮咳嗽这类的病。同时大小青龙汤都能发水气，那么这也治溢饮，这个是在《金匱》上。我们讲完这些，就知道所以中医这个发汗啊，你拿这几个方剂来讲是各个不同，所以在临床上错了，错了就不行，你像我们方才讲这个二阳并病，他也先发汗，他用这个发汗方法不合适，所以还有大青龙汤证发现，他那个病可见开始就是大青龙汤证，他也许用桂枝汤了，也许用其他的方剂，都是没达到目的，所以这个汗出不彻，与一般的麻黄汤证、桂枝汤证全不同，他不好病，甚至于还出大毛病。这是我们上面讲这些发汗剂里头有这么几个主要的方剂，这几个主要的方剂你心里要有个数，那么其他几个加减方剂你就容易理解。咱们今天就讲到这了。有没有什么特殊的反应，自和这就自愈，上次这个 59 条啊，就是一个

自愈的一个例子，说“下之后，复发汗，小便不利者亡津液是也，勿治之，得小便利，必自愈”。

李冠杰：这个条文，《康平本》和《宋本》互相之间有一点差异。《康平本》“亡津”是旁注内容，后边是“小便不利者”；但是在《宋本》成了“小便不利者，亡津液故也”。这也能证明王叔和第二次改动的时候，明显有润色性的那种修整。如果咱们就按《康平本》的这个排列顺序的话，宋代的人如果把这个注解文字挤进去，这个字面上也是通的。你看“大下之后、复发汗、亡津、小便不利者”这也是通的，没有必要再改成“亡津液故也”，而且还挪到后头去，没有这个必要，那么谁可能做这事？就王叔和第二次整理的时候，他觉得这样改了以后文字更通顺一些，只有这么一种可能性。

下边呢我们解读一下：

这一条如果仅仅从字面上理解的话，比较简单明了，论述的就是因为汗下颠倒使这个人体津液虚损严重，以至于发生了小便不利的这种症状。而且明确地提出来，对这一类的情况不需要治疗，等待人体津液恢复以后，就自愈了。这一类的条文，说的是不让你治，那就是一个不需要治疗的。这种条文就让人感觉到不重要。虽然有症状，但是不涉及方子，显得就不是很重要。如果我们仔细地去推敲一下的话，这里边有好多问题，我们需要澄清的。如果站到作者的角度上来说，他说了一个不需要治疗的病，里边本身就蕴含着想通过这种论述去理解人体的病理、生理方面的许多内容。比如，本来就是汗下颠倒，大下之后复发汗，这不是汗下颠到了吗？再说他也不是需要下的一个病，这本身就是一个典型的误治。那么误治以后，而且还是大下之后，为什么没有发生其他类型的疾病呢？他为什么没有变成阳明病，或者少阳病？这里边还有问题，整个这一段最后那个条文也是类似的误治，但是那却变成了阴证，而且是很重的阴证。作者想跟我们说什么？之所以造成这种局面他得具备一些前提条件。比如说啊，一个是患者

他最初患的病，一定就是一个纯表证患者。大家可能会想，那人家说的不就是表证嘛。但是，别的条文有的也说伤寒发了汗以后，反倒是人晕得不得了，那不是纯表证。尽管他头里说的是伤寒，但是他说的不是一个纯伤寒，那是外有表证里有停饮哪！

像这儿经过大下又发汗的，没有造成其他疾病的话，这种人体恐怕就是个表实证，连表虚证的可能性都比较小。为什么呢？因为只有病浅，才经得住这一番折腾。他得有这么一个前提。第二个呢，这一类患者平素身体相对比较强壮的，如果说相对比较弱的，他肯定就会发生其他的病变了。还有另外一种可能性，这个患者很可能在大下之前就存在着一定程度里实的倾向，尽管不一定是个确确实实的实证，也许有里实的倾向。因为有里实的倾向，下得过一些，毕竟病和方剂有一定的相对应的成分存在，所以说对人的伤害也会相对要轻一些。如果没有上边我们分析的这些因素存在的话，像这种大下之后复发汗，就是下之后复发汗出现变证的情况有得是，论述的有的是，别说大下了。所以，应该有这方面的因素存在。理解了以后，我们对人体的生理方面会有进一步的认识。慢慢地、潜移默化地这些东西就变成了自己的东西，你慢慢就会体会到。

前两天就碰到一个病人，这个病人也是我的一个老病号了。他在我这儿三年多，有病就在这儿吃，吃点药就好。这段时间因为他生活环境有一些变化，他得了个病，右小肚子这个地方长了一个瘤子。我让他去检查他也不检查，他就在我这儿吃药，吃下去就明显见轻了。过一段时间，好像这个轻的速度又慢了。后来药吃完了又来拿药，我在给他药的时候，就跟上次的方剂比较接近，我很少两次复诊都用一个方子，很少。我稍微做了点调整，但是方向是一致的。他吃了以后，他就跟我说，他说我这次药吃了很不舒服。后来我一想，我就问了问他的症状，我说你现在上着班的吗？他说没有，放假放了好几天了。我说这就是原因，你把药量减下来，减一半。他减了一半以后，他就

回来跟我说，哎呀，这次吃了很舒服了。那么这是为什么呀？实际上这就是你对病理的一个理解。他以前生活压力很大，这一段时间休班以后比较清闲，清闲了人体的能量就会增加，能量增加以后他就恢复疾病。在恢复疾病的时候，这人体在走上坡路的时候，如果身上有疾病的话，他也会有些症状反应。比如有些亚健康的人，这一年到头他不感冒，到年终了休班的时候才感冒，好好的不知道为什么就感冒了发烧，实际上就是这个病理。如果你不懂其中的道理，那病人这样要真找到你来，你就一头雾水了，你不知道该怎么处理了。上边说的因素，就是这么个问题，

这个地方还有一个典型的症状，“小便不利”。这儿说的“小便不利”绝对不是那种小便量偏少啊、或者小便次数偏少啊，不是这个。他实际上是一个很明显的症状。在这个地方把“小便不利”作为仅有的一个症状，就是因为这个小便很严重啦，或者长时间不解，或者想去解几乎没有，就解一点点，或者解的时候有点难，甚至涩疼的也有可能。应该是一个比较明显的症状。

那么在这儿啊，无论是大下之后也好，还是服发汗药也好，其中任何一个都是大量消耗人体津液的治疗方法。津液在短时间内消耗得就比较严重。下法是让体液在肠道里边随着大便都排出去了；汗法就使水分从皮肤里边大量地排出来了。当人体在短时间内大量地消耗了体液之后，小便排出量自然就会减少，像这个就是比较严重了，他减少的程度也很严重。其实道理很简单，高温的夏天你哗哗地出汗，尽管觉得你喝水不少，但是小便明显得比春秋和冬天要少。古人也在临床当中看得很透了，这人小便闹到这么严重的程度，尽管小便不利是一个非常严重、非常重要、非常突出的一个症状，就是因为有误下、误汗这样的误治经过，人体津液损失严重，有这种症状是正常的，这说明还没有伤及到脏腑。要如果伤及脏腑的话，他可能就会下利不止，或者肠道里的食物因为有热结成里实啊，这也有可能了。这儿呢都没

有，他仅仅是表现为小便不利，这是正常的反应，你就不要再用医疗手段去干预他，让他自愈就行了。

下边作一个小结：伤寒病，如果医生用了猛烈的泻下方剂治疗，见病不愈，又使用发汗的方法治疗，若患者仅限小便不利的症状，不要妄加治疗，待津液恢复后即可自愈。

第 60 条：

胡希恕：这个汗下乱用啊，那么下之后没有再发汗的。那么一般的要是个太阳病，如果吃了泻药，表不解，那么气上冲者嘛，那是表不解了，还可以吃桂枝汤，但是不能用麻黄汤。那么这条说的就是用麻黄汤发汗，他这个书说发汗啊都指着麻黄汤。可是下之伤其里，就是里虚了。复发汗，又虚其表。那么这样子治疗啊使表里俱虚，所以“必振寒，脉微细”，这是个倒装句。那么表里俱虚了，表虚，这个表虚不固。振寒者，就是打颤颤，他说打颤颤地怕冷，这就是虚得厉害。脉微细就说是里虚的情况。那么这个病应该怎么治，后头就有了，这个在原则上说，他说下之后再发汗，往往造成表里俱虚，这个人起码要振寒，而脉微细的。他这个书啊，因为我们讲的太阳病，太阳病的治疗呢依法当发汗，他讲的这些。那么就是虽然讲的是太阳病，如果要是这个人汗下失法，或者是发汗不当，这都属于误治，容易造成很多的疾病的所谓逆证呀，就是治坏的病啊，那么这个呢我们研究太阳病也不得不知。但是底下这一系列方子并不都见于太阳病，这个我们要理解。底下就说了关于表里俱虚的治疗。

李冠杰：《康平本》后面的文字是嵌注内容，嵌注就是夹在正文，也就是夹在《汤液经》条文里边的，夹在这个行里边的一些小字，实际上也是注解内容。通过我们解读啊，这一块内容相对比较复杂一点。但是这一块内容水平也比较高一些，恐怕是出自张仲景之手。这个注解是：“所以然者，以内外俱虚故也”。

这个条文按《康平本》是 80 条里边的一段内容。“下之后、复

发汗”就不需要多说了，标准的就是个误治。在“下之后、复发汗”前边，应该有“伤寒”两个字。因为这是同一段，前边冠以“伤寒”。具体治疗上，这儿没有用“大下”，显然跟刚才那一条就程度上有一点差异，有一点区别。按照经方的治疗原则，一般情况下，太阳病误用了下法以后，表如果还不解的话，就要用桂枝汤来治疗。但是，“复发汗”这这也是一个误治。所以说这个“复发汗”，指的是麻黄汤类的方剂。

这一类的误治啊，常见这么一类情况：“必振寒脉微细”。“振寒”是一个什么状态？这是一个病症的名，指的就是发冷而且震颤这么一种症状。放在这一条里边，就是因为误治造成表里俱虚，所以出现这样的症状。“脉微细”是既微弱又细小的这种脉。但是并没有提到沉，不一定是沉脉。这种既微弱又细小的脉，就是表里俱虚的一种证候。

后边是注解内容“所以然者，以内外俱虚故也”。应该说这个注解比较精道，跟症状和脉象都能统一起来，做了病理方面的这么一个解释。但是始终没有给出治疗的方法，病理解释还是不错的。

看这一条病因、病理、病症都全，但是却没有给治疗方法。因为在其他的条文里边有类似疾病的治疗方法，所以这儿呢，就不作详细地论述。这一类的情况，有可能会出现桂枝加附子汤证，当然出现那个证，还得要别的症状反应做证据，这儿呢就没详细地论述。

做一个小结：伤寒病误用泻下的方法治疗之后，见病不解又施以发汗方剂，则可能造成患者出现振寒脉微细的症状，这是由于表里俱虚的缘故。

第 61 条：

胡希恕：“下之后，复发汗，”这就是接着上一条，“昼日烦躁不得眠，夜而安静，不呕，不渴，无表证，脉沉微，身无大热者，干姜附子汤主之”。

这个他没提振寒，大概也振寒，不提了，光提个脉，脉沉微。那么这种的病就是，这条主要的意思，让你学辨证，正面的反应太少，所以从正面来辨这个证啊比较困难，所以他从侧面来，这个除外，那个除外，那就是他了。这段讲的就这个。“昼日烦躁不得眠，夜而安静”，这讲烦躁的。咱们讲烦躁，三阳病都有烦躁，这个三阴病也有烦躁。烦躁最厉害的莫过于栀子豉汤（证）了，虚烦不得眠嘛。要如果是栀子豉汤这个烦躁的话，那么他不会夜而安静，是昼夜全是那么烦躁，所以这个就说他不是栀子豉汤证。

不呕，这个病由表传到半表半里是要呕的，那么说明这个烦躁也不关乎少阳病。不渴，里头有热，人是要渴的，阳明病啊，他不渴，所以这个烦躁啊也不关乎阳明。无表证，也不是表不解那个烦，他没有表证，尤其是脉沉微，身无大热，这个大热呀有两个看法，一个就是表热，表热我们头前讲过了，“淅淅发热”，感觉这个热呀笼罩体表而不开，这么一种热。还有一种阳明病身大热，不恶寒但恶热，蒸蒸发热，他这个无大热呀，既没有表热，也没有阳明病那种蒸蒸发热，这个纯阴证啊有时候外边带点热，我们后头学四逆汤证的时候就有了。

那么他这个呢一样一样都给除外了，既不是栀子豉汤虚烦证，也不是心烦喜呕少阳病的那种烦，也不是胃家实，渴而烦的那种烦，也不是，同时也不是表不解那个烦，外头没有大热，既没有表热，也没有阳明之里热的这种外证，这肯定是阴证的烦躁。

这阴证的这个烦躁最坏了，那么古人这个看法全是说这个阴阳绝离，这是个术语，就是正不胜邪了，就是脏器胜不了病邪了，所以他烦躁，这个还是躁多而烦少，躁者乱也，这个在阴证里头最危险的一个证候，所以他用这个干姜附子汤主之。所以他这个书从多方面给人指示，也有的正面证候太少，就是一个脉沉微，一个发烦躁，发烦躁这个病症啊关系方面太多，那么当时确诊不了啊，怎么用药呢？所以

他就从侧面了解，正面反应太少。所以他一样一样排除，是不是虚烦啊，是不是少阳病啊，是不是阳明病啊，是不是表未解啊，他把它都除外了，那么说明什么呢，真正由于汗下失法，造成里虚阴寒证，这么一种烦躁。干姜、附子这两味药，古人也说附子不得干姜，不足建其热，这也是一种术语说法。这两个药全是温性热药，这个附子偏于治下，比如下利呀偏于用附子，全是温里的药。要是呕吐呢常用干姜，所以干姜温上。那么这两个药搁在一起，就是彻上彻下，所以里头真正有阴寒非这样不可，他是把这两个药放在一起，而且量非常的重，你看着虽然一两干姜，但是这回是顿服，就一剂，一剂 1 两那么合后世 1 两就是 3 钱，3 钱干姜配合 1 枚附子，这量就很重了，比四逆汤都重。所以阴寒的证候见到烦躁不宁，这不是好现象，这是脏器不足以胜邪，这就是精气欲脱的这么一种反应，所以用这个方子。这个方子再加甘草就是四逆汤了，他的这个病啊不急迫，只是烦躁脉沉微，没有其他的急迫的证候，所以他不搁甘草。你象四逆汤证下利清谷等等的，都有急迫的证候，用甘缓的药，搁甘草。古人用附子呀遇到救逆，温中的时候，都搁生的，生的是有力量的。现在附子都是制的，也不论个了。一个没法考据的，大个的附子都 1 两 8 钱的，小的 3~4 钱 2~3 钱，我们现在用呢就附子、干姜等量用就行，干姜 9 克，附子也用 9 克就行。

生附子有毒啊，咱们得另学用，同时要注意一些，不要跟他这个原方是生用，咱们也生用。就是用生用也药不死人啊，不能说药死人，但折腾人，常常使人头眩，头眩冒，常有这种情况。大量用也能死人的。这是一节，由于这个汗下失法，下之后再发汗，没有这个治法，没有不虚人的。虚到极点了，就转变阴证，那么脏器沉衰，不足以克服疾病了，人就要死了，这个时候就要用干姜附子汤。干姜附子汤方干姜一两附子一枚（生用，去皮，切八片）上二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。上二味，以水三升，煮取一升，去滓。

李冠杰：“下之后、发汗”在《宋本》是“复发汗”，多了个“复”字，也没有严格性的问题，但是这肯定也是误治。因为跟 80 条是同一段内容，所以“下之后、发汗”前边应该有“伤寒”，也是对伤寒而言。虽然上边这几条误治的方法都比较相似，但是这一条所论述的却是一种较为严重的变证的情况，因为出现阴证了。从这儿也能看出来，同样是类似的误治，有的没有发生实质性的病变，有的就发生了很严重的病变。这里边就必然有不同的情况在里面隐含着。我们就不能仅仅是理解字面的含义，一定要理解字里行间所真正表达的深层次的东西。只有这样，才能既不误读又能从中学到更多的经方理论实质性的内容。这一大段是类似的误治，而且治的是同样的病，但是在不同人身上，人体不一样就会出现各种各样的情况，治疗的方法就得跟着变。

“昼日烦躁不得眠，夜而安静”，后边还有，“脉沉微、身无大热者”，这是本方证主要的症状反应。“昼日烦躁不得眠”这一类的叙述在经方里边不是很多。“昼日”不就是白天嘛，白天烦躁不得眠。你要是从道理上说白天不是睡觉的时候啊？他睡不着就睡不着吧！不是！他另有目的，还有其他的用意。后边咱们一点点剖析。这个古人写东西啊，很精妙。仅从字面上说，就指的白天患者表现出来明显的烦躁症状。怎么明显的烦躁的症状？人得病了又误治，你要想休息休息都不行，无法入睡。“夜而安静”，到了晚上反而是没有明显的症状反应了，能够正常地入睡了。实际上，在这个方证当中是一个有特征性的症状反应。

我们客观地来理解，并不是所有的干姜附子汤证患者都会出现这种症状。但是，他这个症状却具有一个特征性，再一个能充分地反应出这一类方证的病理状态。而且这里特别强调白天烦躁晚上安静。他是要让读者去跟其他的具有失眠症状的那些方证加以区别。柴胡加龙骨牡蛎汤，就能治失眠，你得有柴胡加龙骨牡蛎汤的证，同时有失眠

的话，吃它绝对管用。而且这是经方书里面没有说的。酸枣仁汤证、黄连阿胶汤证、栀子豉汤证都有虚烦不得眠。都有不得眠这个失眠的症状，而且明文都写出来了。只有干姜附子汤证的失眠，是“昼日烦躁不得眠”，这个失眠很特殊，他是白天睡不着觉。其他的重点是晚上睡不着觉，那才叫真正的失眠呢！他这个不得眠，是白天睡不着，其实就是烦躁、人难受。强调白天，就是要提醒读者去跟那些方剂做一个鉴别，不要把它看成是因为虚弱证造成这种失眠，不是！这一个虚寒了，而且虚寒得很特殊。

为什么这种虚寒证会出现这类情况呢？相对说这个病因在这一条里边就显得比较重要了。本来是一个表证，可以想象得表证的这个人，平素他体质恐怕就比较虚弱。总之，既有人体素虚的因素，又有治疗太过的因素存在，才能致使人体在短时间内，陷入机能沉衰的阴证。因为他是短时间内造成的这种病理状态，所以他还有一点亢奋的那种趋势，在这种情况下，就出现了白天的时候，他难受、他烦躁，到晚上他就安静。实际上这是人体的自然节律的一种反应。中医里边常说，从下半夜开始人体阳气就一点点地回升了，一直到中午阳气达到顶点。按我们现在的话说，可以理解成人的生物钟。白天的时候，人就会逐渐地处于一种兴奋的亢奋的状态，到了晚上，会逐渐地进入一种比较抑郁的状态。恰恰就因为在短时间内陷于阴证了，机能又不足了，他这个病程又不是多长时间造成的，所以他就处在很微妙的一种病态当中。白天兴奋的时候呢，人体还有能力与疾病作斗争，在作斗争的过程当中人体正邪相争，白天一天的和疾病的折腾，到了晚上以后人的能量更加不足，再加上本身人的节律处于抑郁的状态，就放弃了与疾病的抗争。进入这样一种状态，反倒是安静了。按我们今天形象地说啊，这个人感冒了，误服了那个泻下的药，拉了肚子以后病还没好，好像感冒还在啊，让别人再看，说他这是感冒需要吃发汗的药。吃了发汗的药，汗出了或者汗出得很多，本来这人就有点弱，现

在就出现一种白天很烦，让他休息一会儿他也睡不着，烦得不得了。到了晚上，很安静地就睡了。大家想想，且不说医者，就说他家里的人也会感觉到他这没什么大病吧？就是白天挺烦的，这晚上不是睡得挺好的吗？而且白天烦哪，也不是有特别的发烧啊，他恐怕没有什么大病吧？反正都会有这种感觉。经方派通过实践当中观察得来，这实际上是一种比较重的症。你要是不看的话，他这个病肯定不会自己好的，如果任他发展下去，他可能就出现器质性病变了。但是你又找不到其他的证据，怎么办呢？这儿就给我们示范了一种很好的辨证方法。

下边“不呕不渴、无表证”，这就是用具体的症状为例子，教给你一种辨证的方法。用现在的说法就叫做“排除法”。“不呕”在经方理论里边，代表没有少阳病，因为少阳病有心烦喜呕嘛。“不渴”，常常用来代表没有阳明病，没有阳明里热。那么“无表证”，没有表证典型的症状反应，像“脉浮、头项强痛而恶寒”这一类的症状啊，基本上都没有。既没有少阳病又没有阳明病也没有阳性表证，甚至连阴性表证也没有，就是说没有表证。实际上这个疾病，就是一种重症了。但是这儿我们应该清楚一点，那个“不呕不渴”，都是范例。“不呕”，一系列的少阳病都在其中了。比如口苦、胸胁苦满、往来寒热都没有。如果把三阳病排除出去，表阴证也都包括了，“无表证”嘛。这样，你再辨证就比较清晰了。

“脉沉微”，这是很重要的一个症状。又沉又微，轻取是摸不到的，非得沉取才能摸到这个脉，而且这个脉还非常微弱又细小，那么这就很说明问题了。这是典型的人体里外俱虚的这么一种情况。他这里边明显地提到了“沉”，就有阴证的那种特征了。

“身无大热”，这种人是表证因为误治，很急速地陷入阴证了。在这种情况下，他可能会有身热，但也不是特别严重，也不是一个主要的问题。他这儿想说什么？就是有一点点身热这也不是阳性证。那

么把三阳病排除了，然后把阴性表证再排除了。还有一个问题，按着我们现在总结的病理辨证，从类型上说，还有一个水证血证气证呢。但是水证、血证、气证都不会出现昼日烦躁，晚上安静这种情况。这个条文最后的“干姜附子汤主之”，一下就把疾病给定性了。就是阴性的里虚寒证，一个标准的阴性的里虚寒证。

下边作个小结：伤寒病误下之后，又施以汗法，当患者表现为“昼日烦躁不得眠，夜而安静”的这种症状的时候，则要仔细观察有没有阳性症状存在，如果既没有呕之类的少阳病的证候，也没有口渴之类的阳明病的证候，同时也没有表证，而且现“脉沉微”，“身无大热”的，为干姜附子汤主治之证。

这个方剂只有两味药组成，干姜一两，附子一枚，附子是生附子。这个方剂在临床当中服用方法，要求“顿服”。尽管看着量不大，“顿服”这个量还是不小的。因为这个证还是来得比较快的。这个方子可以看成四逆汤去掉甘草，而且增加了附子的比重。实际上就是说，振兴人体机能的功能就比较强一些。那么为什么要去掉甘草呢？他虽然病来得快，而且也比较重，但是从症状上看，他没有很急迫的症状，就是白天烦得睡不着觉，除了这个以外，没有其他的明显急迫的症状，所以把有缓急迫作用的甘草去掉了。同时也免去了对其他两味药的药性的缓解作用。甘草不但能够缓解人体的急迫症，也能缓解药物的比较剧烈的一些作用。

下面看看方证。

症状：烦躁、厥逆、纳呆、咽痛。实际上这个“昼日烦躁不得眠、夜而安静”应该放到这个前面。但是统计资料里面却没有。因为这是一个特征性的东西，我们应该补上。

舌质：淡舌。

舌苔：白苔，有的薄腻。

脉象：沉脉、细脉、紧脉、弦脉、微脉、数脉、结代脉。洪大之

类的脉就很少。

对应的现代病：心力衰竭、心肌梗塞、休克、急性胃肠炎、吐泻太过、胃绞痛、腹痛、腹泻。还有书上说各种急性病后期之虚脱。大家你去品一品，他确实能代表这个方剂的病理特点。

最后有一个问题，第 80 条整个这一大段，包括 59、60、61 条咱们都学过来了。反过头来整体地通读这个条文，不难发现，这一大段条文就是论述了太阳表证误用先下后汗这一类的方法治疗，因为病人体质、病情和所用的治疗方剂等等这些因素的不同，则可能造成多种常见的不良后果。这里边论述的就是这个。同时也给出了必要的治疗方法。我们真正要从中得到的是什么？从这个基础上我们再去举一反三，其他的病也是这样，其他的治疗也是这样。正治有时候还是会出现问题的。关键是你能不能把经方的理论吃透了，把它掌握了，把它用起来，这是关键。这儿实际上都是举的例子，应该去举一反三，去联想很多其他东西，而且要和临床结合起来。

还有一个，王叔和第二次整理的时候，把 58 条之后的三条都给移走了。他无意当中就把刚才咱们通读的这个含义就给割裂了。当然，在别的地方，你也应该能把他要说的这些意思联系起来，但是拆开以后，这些条文之间的内在的联系，就变得不那么紧密了，常常就会给忽略掉。

第 81 条：

胡希恕：梔子是苦寒去热的药，所以用梔子为主药的这种方剂，这个病人旧微溏，有习惯性的大便溏泻，这是久寒的病。那么久寒，这个梔子是万万用不得的，尤其这个梔子与黄连，都治烦了，黄芩，它们不同的，这个黄连、黄芩呢能治泻肚，梔子不行的，你看看治下利的药都不用梔子，所以这一段他也是大有用意的。梔子这味药啊，它是解烦，同时也去黄，咱们讲到黄疸，梔子茵陈蒿汤里头也有的，它有利小便的作用，但是它不能治下利。这个黄芩、黄连、黄柏也治

烦，但是这些药都是苦燥，能治下利，不利小便。所以它们也有些不同，全是苦寒药，在临床的应用也不一样，在方剂中的应用我们也知道，如果病人烦躁，当然要用苦寒药了，大便要是溏薄，当然就不用栀子，可以用黄芩、黄连这类的药。

李冠杰：先从字面上说，“凡用栀子汤”怎么理解呢？这是指的栀子汤类方剂，这样理解比较客观。如果做另一个理解，可以把他理解成本来写的是栀子豉汤，但是抄写的过程中把字漏掉了，这是一种可能，但这种可能性非常小，而且这样也不太合理。为什么？因为第80条后边这些内容都给移走了，所以说它是紧接着第80条的。它实际上是对着上边的那些含有栀子的方剂说的，而且条文当中用的这句话，跟条文的这个位置也比较恰当。实际上作者的真正用意是想对栀子类方剂的临床应用作一个补充，站到作者的角度上理解的补充，用意还是好的。但是这个条文却理解错了，没理解到点子上。

那下面我们解读一下：

“凡用栀子汤”，刚才咱们说了，就是凡是用经方辨证以后认为需要以栀子汤类方剂治疗的疾病，这儿指的是这个。

“病人旧微溏者”，是指在投这个方剂之前大便就偏于溏泻这样的病人，不能服栀子类的方剂。他道理就在于栀子它本身是一味寒性的解烦去热的药，但是它同时又有缓下的作用，所谓缓下就说它虽然没有大黄下的力量那么大，劲儿比较缓，但是它有这方面的作用。就是说患者本来大便就偏于溏，再用栀子豉类的这种方剂，就可能会加重腹泻。王叔和加上这个条文，实际上就是从这个角度出发的。但是，病人如果碰到了有栀子证又大便偏溏的，怎么治疗呢？其实经方条文里已经给方法了。咱们前面学了，我还特意强调这一点，就是栀子干姜汤，它就是治这个病的。

现在再去看看这个栀子干姜汤，从药性上看是寒热并用，它肯定能治里寒的，从病理上对应的是寒热错杂证。从条文的论述上看，

那个地方本身就有医以丸药大下之，这里边实际上隐含的有下利的余热，只是没有明说而已。就因为没明说出来就差这么一点，你看解读经方机械了就是不行，这就是太机械了，是典型的死于句下。他认为没有提到下利，栀子又是一个泻下的药，甚至他也不会不考虑栀子干姜汤，恐怕栀子干姜汤他就不用过，也不会用，他就等于说是臆造了这么一种情形：如果有栀子证又便溏的就不能服栀子类的方剂了。再看栀子干姜汤的临床治疗的症状和疾病里都有下利，临床实践也能支持这个事儿。

第 81 条是作者还没有真正弄懂经方理论的情况下所作的片面解释。在降两字格排版的条文里，有这类毛病的条文不仅这一条，其它地方还有，不罕见。要如果再进一步地想，假设王叔和碰到栀子干姜汤证，他肯定不会用栀子干姜汤，会用别的方法来代替。从经方治病的疗效来看，用什么方法治疗栀子证恐怕也没有栀子这味药治的好，不一定治不了，但肯定会迁延好长时间。从这一点再往深想，就能够看到后世用方的一些影子，就是因为不能正确理解经方的理论，所以临床中经方用来用去，屡用屡出问题。比如说蒙对了，治好了病了也兴奋一阵，但有些治来治去治不好，就因为经方理论没搞懂。到最后就把经方理论和经方方剂都束之高阁，弃之不用了。现实情况就这么来的。

作个小结：凡属栀子汤类方证，而病人大便偏于溏泻的，可用栀子干姜汤治疗。这个我们就给它改了，因为它原文有错误，小结就给它改了。

大阳病发汗、汗出不解、其人仍发热、心下悸、头眩、身瞤动、振振欲擗地者、玄武汤主之^①、^②（82）

注：

1. “玄武汤”《宋本》作“真武汤”，后同。
2. 《宋本》此处有真武汤方及方后注，此从略。

胡希恕：这一节可与苓桂术甘汤那一节互看，67条“伤寒若吐、若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白术甘草汤主之”，就这一条，这个就是里头有停水，所以吐、下，这都是误治，非利水不可，发汗更不行。上面那个他说是呀，“心下逆满，气上冲胸”，由于停水，表不解，吃泻药，或者吐药，表不解就气上冲，气上冲就心下逆满，气上冲胸嘛。“脉沉紧”，上面这个病要是发汗则“动经”，一发汗，动其经脉，“身为振振摇”，只是身为振振摇，还可以用苓桂术甘汤。

那么这一节呢他是重了，你们好好看看，这个是不会发汗来的，“太阳病发汗”，这个是小便不利，里有停水的这种人，你不利水，只发汗是不行的，这个就是，所以虽然汗出而表不解，“其人仍发热”，表不解嘛，还发热。“心下悸”，就是水逆满于心下导致心下悸呀。“头眩，身瞤动”，这个水气上冲，脑袋就要晕的。“身瞤动”，这个瞤就是跳，身上肌肉或者是筋跳，筋惕肉瞤，这是虚的现象啊。“振振欲僻地”，上面那个“身为振振摇”，只是站不安稳而已，这个呢，振振，打寒战，要倒下，这个是不但表未解，水没去，而反陷于虚极而入了阴寒的证候了。振振就是打颤颤，就是头前说那个“虚故也”。那么这个用苓桂术甘汤不行，得用真武汤。

真武汤也是利小便的一个药，但是它利于阴虚证，那么苓桂术甘汤还是阳虚证，阳证之中的虚证，这个是阴证之中的一个虚证。由哪来的呢，都由于小便不利，而里头有停水，这是给发汗误治了。真武汤方药是这样的，茯苓、芍药、生姜、白术、附子，那么茯苓、术是利尿药了，咱们头前都讲了。那么生姜，他这个水往上逆，甚至于人也有恶心，这个生姜的量用的也挺重，3两，所以搁生姜，心下悸嘛，我们方才讲这个苓桂姜甘汤，就是茯苓甘草汤啊一样的，那个也搁姜。这个水气往上冲逆，但是这个不搁桂枝，没有气冲，并没有心下逆满

这种情形，可能有恶心，这一段没说，我们从方剂中分析可能有恶心。搁芍药，这个水陷于阴证，恐怕里头也有腹痛，这个芍药治腹痛。另外呢由于陷于阴虚证，得搁附子，有振寒，恶寒得厉害。

那么真武汤整个看起来，不但能够治小便不利、振寒、肉瞤、欲僻地这种情况，也能够治里头有停饮，有下利的机转，我们看芍药也是的，而腹痛的情况，那么这个时候他也是良工治未病了，所以这个真武汤啊附子汤，这个我们讲到三阴篇就有了，它也治心下有水气，但是这个全是陷于阴虚证，我们在临床上“遇到”的病人都是恶寒得厉害，尤其有这个振振欲僻地，打寒战，必振寒呐，这个振寒都是阴寒证的一个反映，若是这种的小便不利，头晕，那么你用苓桂术甘汤就不行了，苓桂术甘汤没有阴虚的证候，没有阴寒的证候，这个在后面少阴篇对这个证候还要详细讲的。

所以里有停饮而发汗，这个变证多端啊，你看这都是的，必须得利小便，尤其小便不利，更在表证上必须要利小便而解表，就按一般的发汗法是绝不行的。这个根据桂枝去芍药（汤）那篇以下到这，对这个反复来说明，小青龙汤也是的，小青龙汤虽然不是小便不利，而是心下有水气，心下有水气表不解，你要用普通的方剂是不行的，必须一方面去水，一方面解表，才能够达到表解的目的，换个法就不行。这个在咱们研究的太阳病里头有这么一种客观事实，这是中医的一种特别发现，那么小便不利，有表证，在临床上很容易找到，那么这个时候就是吃发汗药啊，吃吐药、泻药全不行，你非利小便不可，一利小便这表也自然解了，但是这个方剂呢不是一种，不是随便哪个利小便药就行的，这方面的药很多了，桂枝去芍药加茯苓白术汤、苓桂枣甘汤、苓桂术甘汤、五苓散、茯苓甘草汤，这很多。

李冠杰：整个《伤寒论》里边也就有两条是论述真武汤的，在《康平本》里边用的全是玄武汤。看来这个方剂原来的名字就是这样的。

改成真武汤，根据我们现在知道的版本看，有两种可能性：一个

是王叔和二次整理的时候改正的，第二个是宋代校正医书局改正的。实际上后者的可能性大，王叔和去改这个没有太大的意义，这是其一；其次宋代校正医书局他们改这个，很可能是出自当时对某个字的忌讳或者什么的，出于这样的动机去改，尽管他态度非常严谨，能不改的就不改，但是只要是这种原因，他绝对会改的。我们今天就把它统称真武汤就行了，大家都叫习惯了，知道有这么一回事就行了。

《宋本》的条文后边有真武汤的方剂和方后注，《康平本》里面没有，这种情况挺多，《康平本》里边，每一个方剂就出现一次。

下面我们解读一下：

“太阳病发汗”，太阳病本来就应该发汗解表，按照一般的理解好像这句话也没有什么错，应该算是一个正确的治疗。这儿也没有交代是太阳病表实证啊还是表虚证，这个地方实际上没有必要去交代这些东西，没有必要去细究这些东西，因为这一条所说是太阳病发汗出现的变证，这个发汗不是个正治，它是一个误发汗，后边就知道了。

“汗出不解”，在这个地方等于给读者提出问题了，太阳病发汗，应该是正确的治疗，但是汗出不解，为什么呀？前边有过论述，发汗以后不解的像新加汤证这一类的，是因为护理不当这一类的，不一定是方剂不对证。但是这个地方，看后边出现的症状再看方剂，你就明白了，这是一个不正确的治疗。

“其人仍发热”，这个“仍”字在这儿很重要，“仍发热”跟前边学的那个条文里面的“发热”就不一样了，那个明显就有病情转移的味道，这儿没有，这儿就说是继承下来的，还是表证的发热。这个发热在这儿就是跟你说还有表证存在，有表不解的这种证候。

但是表不解的同时，又出现了其他的变证，“心下悸、头眩、身瞤动、振振欲擗地者”，这是一大堆的症状。这是发汗以后又出现的一系列的症状，所有这些症状，都清楚的表明这个患者这个时候存在着严重的体液代谢不良的情况。苓桂术甘汤好多症状跟它相似。实际

上它叙述这个的时候，言外之意说，你当初发汗就不对，这个人本身就有体液代谢不良，有停饮的情况，有这种情况你再去发汗，那么他停饮的情况就更重了，而且表也不能解。所以说前边单纯的发汗就是一个误治。“心下悸”就是心下、胃口这个地方有悸动的症状，这是停饮证的一个典型的症状，茯苓甘草汤它就有这个症状。“头眩”就是头晕啦，虽然说不是所有的头晕都是因为停饮证造成的，但是在这儿它有别的症状做佐证，也是停饮的一个明证。

“身瞤动，振振欲擗地”，这儿跟第 67 条就联系起来了，67 条说“伤寒若吐若下后，心下逆满、气上冲胸、起则头眩、脉沉紧”，这是苓桂术甘汤证，如果在这种基础上再发汗，发汗则动经，那就了不得了，人就要发生更严重的情况了。那么严重的什么情况？“身为振振摇者”，“动经”也好，“身为振振摇”也好，跟“身瞤动，振振欲擗地”是一回事，等于说是那一条里边想说的一个意思。苓桂术甘汤证，如果再发汗，它就有可能发展成真武汤证。苓桂术甘汤是一个外有表虚证里有停饮的阳性证，如果再发汗，人更虚的话，他就有可能还是外有表证里有停饮，但是人机能沉衰了，就陷于阴证，它就这么一个意思。

这个“身瞤动”实际上是指的身体的肌肉跳动的这么一种症状，再加上陷于阴证以后，人恶寒特别重，以至于寒颤的那种程度，大家想想，肌肉又跳动，就是近于痉挛了，又恶寒得近似于到了打寒战的那种程度，再加上头晕，这个时候，这种人如果自己行走的话，他就很难保持平衡，所以说后边就是“振振欲擗地”嘛，晃来晃去想倒的那个样子。这就是对于外有表证里有停饮的人，你误施以汗法，他所出现的比较重的一种证。不单单表不解，人体也陷于机体沉衰的这种阴证。

为什么那个苓桂术甘汤证，它又吐又下的，出现了那样的情况，而没有直接成为为真武汤证呢？如果是误发汗的话，也未必不能出

现，其实你没有误治，也有的，临床当中不是有得是吗？我们这么想象，本来是表证，你误发汗以后，他变成苓桂术甘汤证，这时候你用苓桂术甘汤治疗。又来了一个人，也是外有表证里有停饮证，发了汗以后，他变成真武汤证了。这里边区别在哪？在于这两个人体体质不同，平时健康状态相差得挺远。这里边就应该有这样的因素。

这个事我现在体会挺深，对于健康状况不同的人，至少你辨证正确以后，药量上你都得跟着变化，这一点挺重要。时间长了，大家在临床当中也能体会到。实际临床当中，我们常常见到的，并没有经过这些误治，出现真武汤证的有得是。这儿又说到病因的问题了，大家应该正确地来看，病因，应该跟那个它要解释的病理联系起来，这样你才能正确地理解经方的内涵。

剩下的还有一个问题，治疗这样的病人，一旦有了阴证，其他的证都不重要了，这个阴性证就是一个主要矛盾，阴性的停饮证是一个主要矛盾，表证是一个次要的。“汗出不解”也是个表证的问题，表还没解。真武汤它可以解表啊，道理跟五苓散解表是完全一样的，它两个就是一阴一阳，一个对的是阴证一个对的是阳证。五苓散里面桂枝有解表的功能，但是没有表证的时候，桂枝在里面还有降气冲的作用。可是真武汤里面有生姜，生姜可以解表，但是没表证的话，生姜在这儿还有健胃降逆去饮的功能。

这个条文的病理是阴性的水证兼里虚寒证，表证在这这个地方，咱们给它加一个或然的定性。

下边做一个小结：本为太阳表证，但发汗后，得汗出而表不解，患者仍发热，心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地的，为真武汤主治之证。

这个方剂有五味药物组成：茯苓三两、芍药三两、白术二两、生姜三两、附子一枚。茯苓白术都是去饮的药，生姜温胃降逆去饮，而且它还有解表的功能，所以生姜在这儿还是显得比较重要的。“心下

悸”大家看这个方剂里边谁治啊？茯苓和生姜加在一块儿。苓桂姜甘汤里面有这两味药，两味药在这儿有治疗这种“心下悸”的效能。芍药治因为血虚而致肌肉组织因失养造成的拘急疼痛，像身瞤动、肌肉的拘急、拘挛这一类的情况，还有腹痛这一类的。

记得有一个人曾经这样介绍过，有一个朋友对真武汤用的比较熟道，然后他就打出一个牌子专门治疗痹症，主要是在真武汤的基础上加减，在治疗去饮解表的同时治疗痹症，但不是指所有的痹症都能治。所谓治疗痹症实际上芍药在里边起了相当重要的作用。

真武汤临床当中是一个应用频率很高的方剂。临床统计资料统计到的医案就是 400 多例，症状也统计得非常详细。症状里边出现频率从高到低排列：食少纳呆、浮肿、咳喘、腰膝酸软、肢冷形寒、头目眩晕、小便不利、神倦、心悸、腹胀、恶心呕吐、面色白、身瞤动、便溏、下利、腹痛、胸闷、痰白量多、窒息这是常见的一些症状。

舌质：有淡舌、有齿痕、暗紫舌、红舌、胖大舌、有瘀点的舌。

舌苔：白苔、白腻苔、白滑润苔、少苔或无苔、黑灰滑苔、黄腻苔。

脉象：沉细脉、沉弱脉、细弱脉、沉迟的脉。那么要折成单脉呢就说，沉脉、细脉、弱脉、迟脉。

真武汤治疗的现代病：慢性肾炎、慢性肾小球肾炎、慢性肾盂肾炎、尿毒症、慢性肾衰、肾病性水肿、尿崩症、尿鼓、阴囊肿大、类脂性肾病、风心病、肺心病、心衰、充血性心力衰竭、心源性水肿、慢性肝炎浮肿、眩晕症、美尼尔氏综合症、高血压、内耳眩晕症、失眠、不安腿综合症、血栓闭塞性脉管炎、失音症、胃肠炎、慢性肠炎、肠结核、慢性风湿性关节炎、慢性支气管炎、慢性支气管哮喘、术后伤口不愈、脓胸、产后水肿、闭经、鼻渊、头痛、慢性痢疾、胃溃疡、风湿热、月经不调、咽痛、疝气、心房纤颤、甲状腺机能低下。

这个方剂我在临床当中也常用，在这儿说几个大家能有点印象的

医案。

一个医案，一个刚结婚不久的姑娘，带着她母亲来看病。她母亲是一个木防己汤证，心脏不好，有时候也心慌。她胖胖的，脉是跳两次停一次，而且间歇得还特别明显，但是脉还是挺有力，甚至有一点点偏大，总体看呢是有点偏迟。问她小便什么情况，小便有一个很明显的特点，她把开水往暖瓶里边倒的时候，听倒水的这个声音，常常这一壶水倒完马上就把壶放地上赶紧往厕所里边跑，她就要小便，小便急迫。我就给她真武汤，但是她说什么中药都喝不下去，让她回去装胶囊吃。到了下一次来，我一摸脉我说你是好了吧？因为她的脉就近乎于平脉了。她说是，我没什么状况。我说你怎么吃的这个药？她说我就装了胶囊吃，一次吃两个，等于说一天吃六个胶囊，大概吃了七八天的样子，后来就好了。这是一个比较能引起注意的一个医案，另外一个呢，就有点特色了。

还有一个非常有特色的医案。病人是一个肺结核病人，等于说他服药的时间比较长了，在他整个的服药过程当中，基本上是一条什么样的曲线呢？就是以小柴胡汤合上小陷胸汤为基础方，热的时候会加石膏，偏寒的时候非常少，这类病都是热证的机会多。但是他有一次来诊情况大变，我在病例上是这么记录的：近来明显有喘的症状。平时基本上就不怎么喘，过一段时间他喘了，他说生活压力比较大，现在工作甚至是晚上上夜班，白天还要去兼职做点什么，病好得就慢一些。来诊的时候又开始喘，腹中常感觉冷，这是很少见的。这个病人只有这一次腹中常感觉冷，如果吃了凉东西就腹泻，头痛、头晕，以头晕为主，左脉沉弦右脉尺沉，总体脉略偏迟，心率是 70，是略偏迟一点。舌质由前的暗变为淡粉色略见暗，舌苔薄白。前胸偶尔有阵痛感，夜尿一次，大便有时候一天解两三次，特别吃了菜以后大便还不成形。这样我给他的是真武汤合上茯苓甘草杏仁汤，药量一共给了他 50 克左右，服 5 天左右，这药服完了就好长时间没过来。后来碰

见他，他说这药服了以后很快就好了。为什么跟大家说这个医案呢？大家要注意的一点，这个人就只出现了这一次真武汤证，其它的时候全部是虚热或者实热，都是小柴胡汤、或者大柴胡汤、或者四逆散，这都用过，都有效，只要是你给他辨证对了都有效，所以他对我也是特别信赖。他有时候跟我说，这么好几年了，每次只要是闹点情况来这儿吃药没有不好的时候，吃点药就好。这儿就应证了一个问题，就是说用药不能机械，看这个病例，要是按体质用药，这个事就值得考虑了。他这个体质也变不了，人皮肤肤色也变不了，人的包括眼睛，大眼睛双眼皮，他早就大眼睛双眼皮，这不能作为用药的依据。

还有一个病人的奶奶说，小男孩三四岁，老尿床，好长时间了，有时候一天尿好几次。我就给了他两个方剂，一个是五苓散，因为他有小便频数，而且孩子身体非常好，我一直没见过这个孩子，德州的。说孩子平时玩啊什么的都行，身体挺好的，就是尿床。给他五苓散和甘草干姜汤，分着用。因为他小便频数比较明显嘛，先让他用五苓散，大概用了两三天以后，甘草干姜汤他喝不下去，他讨厌那个干姜味，后来让他贴肚脐。后来这个奶奶跟我说什么呀？孩子已经五六天再没有尿过床了，这么厉害的中药，对这么一点孩子来说会不会伤及到孩子？我说中医治病啊，是通过改善人体达到治病目的的。

咽喉干燥者、不可发汗、（83）

胡希恕：这个咽喉干燥啊，一方面有热，咽中干嘛，燥，就是有热象，一方面是缺津液，津液枯燥。这个发汗啊，胃热不能发汗，表热才能发汗呢，发汗是个解热的法子，但是对里热、内热都不行的。

津液虚，不能发汗。那么这一条呢，既有热，津液也虚，这么一种证候，尤其在咽喉。这一段就说明，咽喉肿痛这类的病，当然也不可发汗了，凡是咽喉肿痛都是有炎性证候的多，但还都咽喉干燥，所

以咱们对咽痛，都搁到少阴篇是有道理的。

开始时都象外感似的，但是呢咽喉干燥，所以这个是不能发汗的。可是也有这么一种情况，如果在临床上我们遇到外感，以外感为主，这个咽痛不可发汗，一般象这个用葛根汤啊加桔梗，也可以的。但是如果只是一个以咽痛为主的病，那就是有些形似外感也不能发汗，这个要注意啊。小孩子这个病最多，常由感冒，再到咳嗽，嗓子疼，有这个情形，但是不是以嗓子疼为主的，那个嗓子疼也不重，你该用桂枝汤啊，你桂枝汤加桔梗也行，该用葛根汤，葛根汤加桔梗也行。但是确实是以咽痛为主的这种病，那么大概都不能发汗的，这种我们要注意，所以搁到头一条。你象这个小孩子病啊，出疹痘，那么最后余热不尽，回到嗓子了，那么这个时候发汗差不多就能死，非这个发汗封喉啊，所以有一些咽痛之类的病，所谓急喉风这类的，也是嗓子特别干，这个痰干巴到嗓子上，疼得特别剧烈，这种病啊都不能发汗，所以这一段搁到头一条，很有意思。

李冠杰：这个条文呢，在《康平本》为降一字格排版的条文。

下边这些发汗禁忌证的条文都是降一字格排版的，出自张仲景之手的可能性比较大。这些条文是对经方理论的一个发展和补充。

“咽喉干燥”，在这儿的干燥是因为缺少津液出现的明显不适感这么一种症状。一种原因是因为人体由于里热的存在，增加了体液的损耗。那么这个时候呢，人体会整体上缺少津液，因咽喉本来比较敏感，就会首先感觉这个地方不适。第二种原因呢，虽然说里热不明显，但是津液虚了。因为里热是根本的原因，津液虚是个标；有的呢，直接就是津液虚，不一定是里热造成的，小便频数也会造成津液虚的情况。在大多数情况下，因为里热造成的比较多；这两种因素并存的情况也比较多。

在经方理论里边，津液虚损的情况下，即使是有表证，也不能单纯采用发汗的方法。如果强行发汗的话，就造成津液进一步的虚损。

发汗是消耗津液比较严重的一种治疗方法。因为津液进一步地损失，就有可能造成新的疾病。所以说呢，津液虚的人是不宜发汗。

做一个小结：凡是在表证的同时伴有咽喉干燥的，不可单独使用发汗的方式治疗。

那么这儿呢，我想到了李翰卿老中医，他在总结桂枝汤禁忌证的时候，就提到了咽喉干燥，就是咽喉干燥，桂枝汤也不能用。实际上这个咽喉干燥，重点还是指的有里热这一类；如果没有里热，其他因素造成津液虚得厉害的话，单独用桂枝汤也不好。有这一类的方剂，新加汤就是对着这类情况的，津液比较虚又有表证的。

淋家、不可发汗、发汗必便血、（84）

胡希恕： 那么这个淋家也是一种炎症，是亡津于下，那么再发汗夺其津液，必伤阴血，所以发汗汗出之后，这个便血不是小便便血。这个淋家，现在这个病少见了，旧社会这个病多得很呐，是前阴发炎，我遇到过这个病，也有淋血的，出血的，总而言之是伤阴啊，就是伤阴血了。他久伤阴血于下，已经阴血就虚，你再竭其津液，那么阴血受伤，必要便血的。

李冠杰： 这是降一字格的条文。

“淋家”是指的久患淋证的人。这个淋证，是一个病名，它是指的以小便频数、短涩、滴沥刺痛、欲出未尽、少腹拘急、痛引腰脐为主证的疾病。单纯的解释这个淋证，在古代是对一大类疾病很宽泛的定义，它包括了很多类型的淋病，在古代就有石淋、膏淋、气淋、血淋、劳淋、痰淋、暑淋等不同的淋证；另外还有暴淋、足淋、丸淋不痛、丹热、淋脂、精髓枯淋等，这都是指比较特殊的，就是说淋证分若干种。

像上边说的淋证，在现代医学里比如泌尿系感染，结石，泌尿系

的结核、肿瘤，以及前列腺炎、前列腺肥大等。但是这条里论述的恐怕没有这么宽，而且它是指的长期患此类疾病的，“淋家”嘛！凡得这种疾病的人，都存在着体液代谢障碍，要么小便不利、停饮，要么津液虚损都有可能的。根据不同的病，凡是得这种淋证，还常常伴有其他类型的疾病，像里热、血虚啊，刚才咱们从名称里也能听出来，甚至一些阴性证。按照经方治疗原则，仅仅一个体液代谢不良的因素，不管是津液虚还是体内停饮，就足以构成了不可发汗的条件了。所以这儿就把“淋病”做为一个发汗的禁忌证。

长期得“淋病”的发汗会有什么后果呢？这也给列举了一个例子是“发汗必便血”。这样的病人如果误用了发汗法，可能出现便血的重症。

作个小结：长期患有淋证的病人，不可单独使用发汗的方法治疗，如果误施以汗法，则可能出现便血的症状。

疮家虽身疼痛、不可发汗、汗出则痉、^{（85）}衄家不可发汗、汗出则必额上陷^①、脉急紧、直视不能目眴、不得眠、^{（86）}

注：“汗出则必额上陷”《宋本》作“汗出必额上陷”。

胡希恕：85条：所谓疮家，不是起一个小疮就不能发汗了，所以说疮家是颈带疮、痿啊这种恶疮，这也是丧失人的精血最厉害的，这个疮没有不出脓出血的。“虽身疼痛”，身疼痛是表证的证候了，虽然有身疼痛也不能发汗，汗出则痉，他阴血虚，你再夺其汗，这个肌肉组织更枯燥了，完了就要抽。痉，这是一种病名，就是现在咱们说抽，厉害了就是背弓反张，这都是肌肉不和了。肌肉不和有多种原因，这个就是津液、血液枯燥的这种不和。

86 条：衄家，就是鼻子常出血的人。衄家，不是鼻子一次出血，是经常，搁个“家”了嘛，所以这个不是说鼻子出血就不能发汗，而是经常鼻子出血的人。这个是津液亡于上，与淋家正好相反的，那个是阴亡于下，这个是阴亡于上。再一发汗，他额上这个地方，上面血平常就伤耗得挺厉害了，那么你再夺其汗，上部血更少了，额上这个地方没有血液了，就要塌陷，就是这个肉，也可以说是脉管，也可以的，但是还是指着肉，人的体重啊体液占最大的，在人身上占最大的部分，哪个地方体液特别的消失，哪个地方特别显出瘦削的样子。这个人久衄，再夺其汗，那么这个地方更消减了，所以额上陷。那么这个脉呢失去柔韧了，所以要急紧。眼睛失去津液，组织枯燥啊，光能直视而眼球不能动。那么这个脑袋不动，光拿眼球瞅人，古人叫做动目失视。这个地方是眼球不能活动，因为组织枯燥，血液不足以流散了。由于上面这个特殊贫血，血液不足以养心就睡不着觉，“不得眠”。

李冠杰：在《康平本》中它与《宋本》里边的 86 条是同一条内容。由《康平本》改为《宋本》的过程当中，把这两条给拆开了。

解读一下：

85 条：“疮家”，就是久患疮疡的人。这个疮疡也是比较宽泛的一个概念，一类泛指皮肤外科而言，另一类，比较具体一些，是指一切的痈、疽，皮肤病的总称，包括范围很广，如：痈、疽、疔、疖、瘰、疔、疥、癣、疖、痘、疹这一类。“疮家”，显然上边好多属于“疮”范畴之内的这些病，有一些是短时间的急性病，这个不能算是疮家。“疮家”指的不是一般的这个皮肤病，而是较为严重的慢性的这种疮疡类的疾病。这一类的疾病如果长期不愈，大多都得像化脓啊、失血啊，都有这一类的情況。

“虽身疼痛”，咱们可以把它理解成，这样的人或许是发生了表证，或许是发生了近似于表证的症狀，在这种情况下，如果单独使用发汗方法的话，就会使他本来就津血不足，更会进一步地喪失体液，

从而造成机体组织严重失养，而发生像拘挛、抽搐等症状。就是这儿说的“汗出则痉”。“痉病”是一个病名，指的是以口噤，就是口闭而不张，项背强直、四肢抽搐、角弓反张为主证的这一类疾病。

下边做个小结：长期患有严重疮疡的病人，即使是发生表证或者是出现身疼痛等类似表证的症状反应，也不可以单独使用发汗的方法治疗，如果发汗则有可能会发生痉病。

86 条：这个条文在《康平本》里与上一条是同一段的内容。但是，论述的不是相同的一个事儿。条文中“汗出则必额上陷”，在《宋本》为“汗出必额上陷”，少了“则”字，没有原则上的东西。

下边解读一下：

“衄家”，这个“衄家”就是指的长期衄血的人，就是常闹流鼻血的人。但是，需要跟大家说明的，这儿跟那种因为表实证不解所致的鼻衄不是一回事儿，不是一种。鼻子位于人体的头部，长期衄血的人，头部的津液、精血虚损的程度，会比身体其他的部位相对就严重一些。他本身头部精虚血少为主要的薄弱环节，这个时候如果再强行发汗，随着全身精血的虚损，头部的精血虚损的情况就更为严重。就会相应地表现出一些具体的症状。

“额上陷”，这个“额”指的前额，有的书上解释是两个太阳穴，实际上就是指的前额。那么前额怎么会陷呢？实际上，是前额部位因为精血的减少而出现的一种干瘪的现象。这儿说陷只是一种形容，不是真正的塌陷，而是干瘪了，感觉这个地方没有以前丰满，是这种“额上陷”。是组织的萎缩，组织因为精血的减少，出现萎缩。

“直视不能眴”，指人的眼球直视而且活动不太灵便，表现出目光呆滞的这么一种症状。这个“眴”字啊，咱们在这念 shùn，大家可能都在念 xún。这个字呢，有三个读音，第一个是 shùn，“眴”（shùn）有两个意思：一个是使眼色，另一个是受惊的样子。唉，这两个意思跟这个条文里边说的都比较接近。另外呢，还有一个读音念

xún, “眴” (xún) 是目眩的意思, 是头晕的意思。还有一个呢, 念 xián, “眴” (xián) 跟 “眴” (xún) 是相同的, 跟 “眴” (xún) 是一个意思。所以咱们这个地方啊, 应该读作 shùn, 就对了。这个地方如果理解成 “眴” (shùn) 的话——相当于使眼色, 不能眴呢, 就是他没有使眼色的机能了, 就是说, 他那个眼睛没有那么灵活了。再加上前边的 “直视”, 说得非常生动。从机理上说, 这是由于眼部的肌肉组织因为精血虚损而造成的一种失养, 就活动不灵便了, 跟其他肢体失养出现的一些活动不灵便、抽搐有点相似。

这个 “不得眠”, 其实非常简单, 因为长期患有鼻部的出血, 致使整个头部的血液就偏少。如果再发汗, 头部就更加重了这种情况, 他会因为大脑失养, 大脑供血不足也能造成失眠; 大脑供血过了, 血压太高了也能造成人难以睡眠。像里热证造成的心脏跳得特快, 就是供血过多了睡不着。

“脉紧急”, 按胡老的解释: 就是脉管失去柔韧度的一种反应。

下边做个小结: 长期患有鼻衄证的人, 不可发汗, 发汗后可能出现额上陷、脉紧急、直视不能眴、不得眠的情况。

亡血家、不可发汗、发汗则寒栗而振、⁽⁸⁷⁾ 汗家重发汗、必恍惚心乱、小便已阴疼、与禹余粮丸、⁽⁸⁸⁾

胡希恕: 第 87 条: 亡血家, 就是大失血的人。那么这个虚, 头前有了, 所以发虚人之汗, 虚厉害了, 要寒栗而振, 就是打寒战, 就是虚极必要陷阴证的, 就是阴寒证。

第 88 条: 汗家, 就是平时出汗的人, 老盗汗呐, 身上老喜出汗。那么这个不是一般微微有汗, 就不能发汗了, 不是的。所谓这个汗家,

就是久久体虚出汗的人。你再发其汗，那么夺汗者亡血呀，血不足以养心，所以恍惚心乱，小便已阴疼，这是组织枯燥的表现。“与禹余粮丸，这个方剂根本就没有，你看这几段都没有说怎么治疗，是发汗禁忌，举一种证候不要发汗而已，不是一个治疗。那么这个他特殊提出禹余粮丸，这个方剂没有，可能是一个错误，这句话不应该有，根据前后的行文，都没有，单独这条搁个禹余粮丸，没意思。

李冠杰：第 87 条，解读一下：

“亡血家”就是指的大量失血。比如说大出血，或者严重的外伤，或者长期失血的人，像妇女例假长期不干净之类的。我见过这样的人，一看她那脸色都是蜡黄蜡黄的。像这类的人，肯定不要单独给她使用发汗的方法，因为失血过多陷于一种严重的血虚状态，这个时候要发汗容易虚得更厉害。

虚了以后什么表现啊？“寒栗而振”啊，就是特别得怕冷，甚至于打寒战，这只是一个症状啊，完全还有可能引起其他的疾病，出现四逆汤证也是完全有可能的。

做个小结：长期失血或是大量失血的人不可发汗，发汗则可能陷于寒栗而振的阴寒证。

第 88 条与第 87 条在《康平本》是同一条内容，说的也不是相同的问题。

下边解读一下：

“汗家”指的平素有多汗症的这样的人。这一类的人体啊，本来就因为出汗过多而处于一种津液虚损的状态，如果再发汗就容易加重汗出，最终会发生其他的病变。另外，这个多汗大致两种情况造成的：一种是有里热蒸汗而出；另一种是因为人虚。就是说另外最轻的也就是一个桂枝汤证。如果前边说过这儿发汗指的是麻黄汤之类的方剂而言，治疗表实证的，是桂枝汤证误用了麻黄汤那也不行，所以说不可以发汗。

“恍惚心乱”，在这儿可以理解是因为津液虚损而造成的烦躁证的另一种表述方式，实际上就是一个烦躁证，前边呢是因为津液虚而致烦躁的，咱们学习过。

“小便已阴疼”，是指的小便之后前阴有疼痛的感觉。这个是因为组织枯燥所致。

下边“与禹余粮丸”，这个方剂在所有的《伤寒论》版本当中基本上都是有名无方。《桂林古本伤寒论》应该除外，因为那个版本在学术上有争论，真实性值得怀疑。其他的版本都是有名无方。

从这一条上下的条文来看，附近的条文凡是论述禁汗证的，都没有给治疗方剂，单独这一条给一个治疗方剂没有道理。估计这可能是古文中所谓的“闲文”，就是说不知道怎么混进来的，没有用了。《伤寒论》里像这类的文字也不是这一处，其他的地方也有。但是因为它有一个方剂，很多人特别重视，甚至有人都给补充上方剂。后边我们对这一类的情况会做一个讨论，等学习完了大家就会明白，这种补充应该说是没有必要的。

做一个小结：平时有多汗证的病人如果再发其汗，则可能出现恍惚心乱，小便已阴疼的症状。

病人有寒，复发汗，胃中冷吐蛔^①、（89）

注：“胃中冷吐蛔”《宋本》作“胃中冷必吐蛔”。

胡希恕：发汗，是解热的一种手段，非热不能发汗。这个“病人有寒”，尤其内寒、里寒，比如下利清谷就是虚寒在里了，那就不能够攻表，本来就有寒，再退其热，以发汗的法子，那么如果这个寒在里，那里更冷了，就是“胃中冷”，就有蛔啊，就是蛔虫，迫于寒而往上跑，所以蛔上入膈，在厥阴篇有这一段，那一定要吐蛔的。蛔虫由于胃中太凉，迫于这个凉要往上跑。要是入膈了，人就要吐，一

吐，这蛔虫就吐出来了，所以必吐蚘。

那么以上这几条啊虽然是举的各种不同（不可发汗）的情况，概而言之一个就是津液虚、血液虚、有热、组织枯燥，这都不可发汗，再一个就是淋家、疮家、亡血家呀，无一不是这种问题。如果热在里，那更不可发汗了，只能用撤热的法子，发汗不可，当然用寒性药就可以了。那么这几段，在临床上，这个病人似有可发汗的样子，但有这几种情况就不可发汗了。那么怎么治疗呢，就要因证而施了，后头都有的，所以在这他不讲治法。咱们在讲太阳病，主要是以发汗为法的，表证应该发汗。但是有不可发汗的，不得不知。所以我们治病就是这个样子，在正面看这个问题，比如遇到一个病要发汗，这个病人应该发汗，总要考察不可发汗这些方面。那么有不可发汗的，你不能冒冒失失发汗。由于这个汗吐下这三种法子都是攻病的法子，用之得当，那是立竿见影，用之不当呢？危害也相当严重。所以我们头前也讲了很多了，在这他就是集中说了一下。

李冠杰：这个条文的“胃中冷，吐蛔”在《宋本》是“胃中冷必吐蛔”，多了一个“必”字。

下面解读一下：

“病人有寒”，是指素有里寒症的病人。像这一类的病人呢，也不能发汗。这个呢，学到现在也应该知道这是一个常识了。

发汗以后，会出现什么情况呢？“胃中冷，吐蛔”。本来有里寒证的人，如果再给他施以发汗的峻剂，就会加重里寒证的程度。这个时候，如果病人肠道里边有蛔虫的话，就可能因为里寒的加重迫使蛔虫往上行，最终从口腔里边吐出。这个也是古人长期从临床当中观察总结出来的。这个有里寒致使人吐蛔虫的这种情况，如果消化道里边的温度过低，就形成了不适宜它生存的这么一种环境。它就要想办法离开这个环境去找更加适合它的环境。像这种有里寒的人，就喜欢吃热的东西。所以胃部这个温度相对来说就会高一些，它就会往上移。

但是，胃里边有胃酸这个环境肯定不适宜蛔虫在这儿，它来到这儿，它发现反倒是更不适合它在这儿生长，它不舒服了，它就在这儿闹，而且胃里边也不适宜有蛔虫在里边。这时候这两个方面明显的矛盾，最终激烈的反应，人就得吐，把它吐出来。当然这是以吐蛔虫来分析这个机理。现在卫生条件好了，大多数人体内都没有蛔虫了，他不是以吐蛔的方式表现出来，如果有里寒的话，仍然适用于这个条文。

下边做个小结：对于平素有里寒证的病人，如果误施以发汗的方法，则可能因里寒的加重而发生吐蛔的症状。

到这儿呢，禁汗的条文就告以段落了。很多初学的人每当学到类似这样的条文的时候，都会产生一个疑问？如果我们碰到这样的病人应该怎样处理？我们怎么治呢？其实《伤寒论》里边还有很多类似的条文，就是说有病理，有症状，没给你治疗方法。

他把禁汗的条文集中在这个地方，有一个内在的规律，他论述的这一类情况都属于不能发汗的。这个不能发汗的实质是什么？不能发汗的实质就是在表证的同时，还有其他的一些疾病，就是不是单纯的表证，他还有别的病，我们应该怎么治呢？

今天借这个机会，我们也把发汗这个事儿，再重新理解一下，然后从治疗方法这个角度再去看一看，因为这是一个点。在其他类型疾病里边也有这类条文，等我们把这些条文从道理上弄通了，其他的就迎刃而解了。他们不给治疗方法我怎么治呢？我碰到这样的病人应该怎么治呢？上边这么多的禁汗的一些实例，是对顶格条文所论述的不可发汗的进一步地明确，有的属于补充，就是拿出来做一个示范。实际上，《伤寒论》里边也不全。比如说少阳病是不能发汗的，尽管不是以这种方式说出来的，但是很明显的。比如有里饮的不能单纯的发汗，像这一类的就没有说到。

“汗法”是中医八大治法之一，指的是具有发汗作用的药物或者其他的物理上的处理，使患者出汗或者是汗出正常，以达到治疗目的

的一种治疗方法。其实不仅仅是经方里面有禁汗的条文，在《中医辞海》里边也把不可发汗的条文集中了二十条，而且这二十条也不是全面的，我们了解以后可以感悟一些东西。有表证当然需要发汗，但是存在其他类型就不能发汗。例如：

1. 头痛、发热类似外感，但是患者鼻不塞、声音不重、疲倦无力、脉虚弱。这是内伤证，元气不足，不能发汗。
2. 阴虚内热，傍晚时低热显著、脉细数无力，不能发汗。
3. 伤食病：胸满，胀满，吞酸水，嗝出腐臭的味道，身热，寸脉紧，不能发汗。
4. 内有寒痰，手足寒冷，脉沉滑，不能发汗。
5. 脚气病肿胀，不能发汗。这个脚气不是指一般的脚气，中医里边一个特殊的病。
6. 生于脏腑的内忧，不能发汗。
7. 身体发板，不能发汗。
8. 全身拘谨不恶寒、但恶热，不能发汗。
9. 湿温身热，只能化湿清热，不能发汗。
10. 暑症身热、自汗，不能发汗。
11. 外感病应汗，但病人脐部附近有气动，有跳动的感觉，不能发汗，这是有里饮。
12. 身热而脉沉，咽中干燥，病已入里，不能发汗。
13. 少阴病手足寒冷，无汗，不能发汗。要是真的少阴病，就用麻黄附子细辛汤，麻黄附子甘草汤，可以治这类的病。
14. 身热而脉弱，不可发汗，
15. 少阳病往来寒热，胸胁苦满、口苦、咽干、目眩等症，不能发汗。
16. 失血的患者，不能发汗。
17. 剧吐之后，不能发汗。

18. 峻下之后，不能发汗。

19. 淋证患者，不能发汗。

20. 妇女月经事来，不能发汗。

其实这二十条也不全。

实际所谓禁汗，都是伴有表证的同时带有其他类型的疾病。我们要碰到这些该怎么去治呢？如果能整体解释经方理论的话，这根本就不是一个问题。我把《伤寒论》和《金匱要略》里边，即有表证又有其他类型的疾病的这一类的方剂，都汇集了一下。按照病理分一下类，在这里我和大家先罗列一下，听完之后你会有感觉的。上面所说的不可发汗的情况，几乎都包括。

先从发汗说：

阳性：

表实证：麻黄汤、葛根汤、葛根加半夏汤、麻黄甘草汤、麻黄醇酒汤。

表虚证：桂枝汤、桂枝甘草汤、桂枝加葛根汤、桂枝加黄芪汤、桂枝去芍药汤、桂枝加芍药汤、黄芪桂枝五物汤。

既表实证又有表虚证的：桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤。

阴性：

表虚证：桂枝加附子汤。

表实证：麻黄附子细辛汤、麻黄附子甘草汤、麻黄附子汤。

阴性表证兼有里热：竹叶汤。

阴性表证兼有里虚寒：白通汤、白通加猪胆汁汤、桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤、桂枝去芍药加附子汤。

阳性表证兼有里虚寒证：桂枝人参汤、小青龙汤（它有里饮又有里虚寒的情况）。

阳性表证兼有里实证：桂枝加大黄汤、厚朴七物汤。

阳性表证兼有里热证：大青龙汤、麻杏石甘汤、白虎加桂枝汤、越婢汤、麻黄连翘赤小豆汤（麻黄连翘赤小豆汤还兼有里饮）。

阳性表证兼半表半里证：柴胡桂枝汤。

表实证兼有水证：大青龙汤（体表停水），小青龙汤（里饮），小青龙加石膏汤，麻黄附子细辛汤，麻黄附子甘草汤、麻黄加术汤、厚朴麻黄汤、射干麻黄汤、越婢加术汤、越婢加半夏汤、麻黄连翘赤小豆汤。

表虚证兼有里饮：桂枝去桂加茯苓白术汤、白术附子汤、苓桂术甘汤、苓桂枣甘汤、茯苓甘草汤、桂枝附子汤、桂枝去芍药加皂角汤、真武汤、五苓散。

表证兼水虚：桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤、瓜蒌桂枝汤。

表证兼血虚证：当归四逆汤、当归四逆加吴茱萸生姜汤、

表证兼气逆证：桂枝加桂汤，桂枝加厚朴杏子汤。

表证兼情志方面疾病：桂枝甘草加龙骨牡蛎汤、桂枝加龙骨牡蛎汤、桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎汤。

表证兼虚证：薯蓣丸，小建中汤、黄芪建中汤。

根据这些推而广之，再组方、和方、加减，那么还有多少方子就无法计算了。

例如：小柴胡汤合小青龙汤，既有半表半里证，又有表实证又有里饮，里饮还是寒饮。小柴胡汤合上葛根汤怎么样，这都是常用的方子。如果举一反三推而广之的话，这就很宽泛了。说到这儿，大家就很明确地感觉到，即使没有给治疗的方法，我怎么去治，实际其他地方都有，学了类似的条文，大家都应该思考问题

本发汗、而复下之、此为逆也、若先发汗、治不为逆、

本先下之、而反汗之、此为逆^①、若先下之、治不为逆、（90）

注：“此为逆”《宋本》作“为逆”。

胡希恕：因为这个病啊本来是应该先发汗的病，而不发汗，而反下之，这就是施治之逆了。如果先发汗呢？治之不为逆。这是一个讲法，还有一个意思，本来先应该发汗，而先下之，这是施治之逆。如果先发汗了，那么发汗之后有可下的证候而下之，治不为逆。这么讲也通的。但是底下这一条啊就不行了，“本先下之而反汗之，为逆”，那么应该先下的病，而反发其汗，这就是治逆。如果先下之呢，“治不为逆”，这个就不能这么讲了，根据上条说本来应该先下，而反先发汗，这是施治之逆。要是下之后，有发汗的机会再发汗，这是治不为逆，这么讲在理论上是讲得通的，但在实际上没有，没有一个病啊先可以泻下的病，象阳明病了，泻下完了还发汗，没有那个事。所以根据这一条知道上面那一条啊，也不能作那个解释。

本先温之而反汗之，为逆，若先温之，治不为逆。先温，后再解表是可以的，这后头都有的。但是这个下，是没有这个例子的。我们在临床上也没有这种实际的病的反应，也没有这个样子的。所以这段讲还根据头前那个讲对，就是病啊有宜汗的，有宜下的，那么古人说了，阳盛阴虚，汗之则死；阳虚阴盛，下之则亡。所以该下的发汗了，或者该发汗的下了，都是逆治。别看刚才说的是后世的说法，其实是内经上的。这个地方阴阳啊，阳就指着热，阴就指着津液。阳盛阴虚，就是津液亏，他还去伤津液，这个津液不能让它亏。这个书不这么讲，这个书这个阴阳啊与内经上所讲的阴阳是不同的，他这个阳常指着津液，咱们头前有很多条文了，回头看看。他说这个阳盛就是热盛，阴虚就是津液虚，这个不能发汗。热不盛，而津液特别充分，可以发汗，他这么说的。这个是有语病的，我们讲这条可以的。能真正阳虚，真正没有热，也不能发汗，你可知道啊，所以这句话有语病，所以甚至于说“桂枝下咽，阳盛则毙”，都指着热盛。其实桂枝汤治的病哪一

种没有热？都有热，那个热是表热，不是说是有热就不能用桂枝，这是错的。表有热，还是非用不可。所以拿内经来注解伤寒论，有的地方就注得不通。

李冠杰：这个条文中的“此为逆”在《宋本》当中是“为逆”，没有“此”字。

下面我们解读一下：

这个条文是降两字格排版的条文。这个条文作者的本意是经方理论中“汗下”的治疗原则，他加以总结和明确。但是我们仔细推敲一下原文，分析一下，你会发现，由于作者对经方理论理解上存在的偏差，这儿不能不强调这个问题，和作者本身水平的限制，有多数不妥。

下边直译一下：本来应该先发汗治疗的疾病，反而使用泻下的方法，为错误的治疗；如果先发汗，就不为错。本来应该先用泻下的方法治疗的疾病，反而使用发汗的方法，就是错误的；如果先用泻下的方法，则不为错。

“本发汗”，如果仅仅从字面上理解呢，应该理解成本来应该发汗治疗的疾病。但是这个条文的后边有“若先发汗”，那么，先发汗是什么意思？就是这里本身就有个先后的问题。这个“本发汗”指的本来应该先发汗的。所以直译时就把它明确了一下。

这个条文论述的是“汗下”的先后顺序，他想说治疗原则的。但是，有一个原则性的问题，存在一个明显的错误。在经方理论里边，没有“先下后汗”的这种情况存在。如果说有里寒的话，应该先温里，谈不到下；如果说有里热的话，要先解表后攻下，或者说同时治疗也行。但是，不存在先下这种可能性，道理上说不过去。

当我们深入地、细致地用《康平本》来对照，按《康平本》携带的信息再学习的时候，会发现这里边有很多活生生的东西，有时候你会觉得你和那个作者面对着面。你好像看到了作者的仪容，音貌之类的，有很多很具体的东西。像这类条文的作者和顶格条文的作者相比

的话，这两个作者在你心目中的位置肯定是不一样的。

伤寒医下之、续得下利、清谷不止、身疼痛者、急当救里、后身疼痛、清便自调者、急当可救表^①、救里宜回逆汤、救表宜桂枝汤、（91）

注：“急当可救表”《宋本》作“急当救表”。

胡希恕：伤寒呀没有下之法，所以他上面说本应汗之，而复下之，此为逆也。看起来是伤寒，法当发汗，而下之，这是错误的，因而造成底下这种情况，续得下利清谷不止就继下药之后没完了，继续下利，同时呢排泄物是清谷不止，清，我们解释过，如厕叫做清，清谷就是排泄的大便完谷不化，清谷的“清”在这块儿是个动词，就是排便，排的都是完谷，而不是（正常大便）。那么本来这里头没有病，这就是诛罚无辜了，由于泻药，里边虚，里为热，由于这个误治，反而为虚寒下利清谷之病了。那么这个时候表还不解，“身疼痛者”，那么这个要是里虚寒，而有表证，应该舍表救里，这是定法，头前也讲了，我们在临床上也是这样的，他不是由于这个误治，那么这个人既有表证又有里证，而里证需要温补，你就要舍表救里。如果里证需要攻伐，象太阳阳明这种并病，那你得先解表后攻里。这是定法，是我们要知道的。

“后身疼痛”，然后再治身疼痛。“清便自调者”，虽然误下，但是清便自调，清便自调就是大便正常了，没有续得下利而清谷不止，没有这种情况，这个身疼痛还是表没解呀，那你还得解表，别管里了，他里没有问题的嘛，这是一个解释法。这还可以这么解释，那么续得下利清谷不止，经过救里而清便自调之后，这时候你再解表，也讲得通。这一段啊也有两个看法，一个说的虽然误下，没有上边的情形而清便自调，那要有身疼痛，急当救表，这个讲法也行；另一个呢，就是已

经有续得下利清谷不止，急当救里，里救之后，已经清便自调了，这阵你再救其表，都讲得通。对于这段文字，这两种说法都有理的。究其实作者着重哪一点，也不得而知。

据我看呢，还有我们头前讲的那个对，一个是应该发汗而误下，误下不一定就得下利清谷啊，不一定的，要是下利清谷呢，这就是虚寒了，这里的定法就是先救里后解表，否则，没有这个情形，身疼痛还是表没解，该解表还得救表。那么救里呢一般用四逆汤，救表宜桂枝汤。为什么用桂枝汤？这头前也讲得很多了，桂枝汤的应用啊，都是根据体液有丧失之后了，发汗后，下之后，头前有嘛，亡血，亡津液，这个时候表不解不能用麻黄汤，这个在临床上很重要啊，这也是定法了。在临床上，无论他吃了其他的发汗药，或者吃了泻药，这个表没解，虽然是不汗出，也不能使麻黄汤，要使桂枝汤。所以这个地方他说救表宜桂枝汤，非常地肯定了，这要注意。那么开始得病就没有汗，那你当然用麻黄汤，在伤寒这个阶段。

李冠杰：这在《康平本》是顶格排版的条文。“急当可救表”，到了《宋本》里就成了“急当救表”了，“可”字去掉了，确实“可”字有点咬嘴，读着不太顺畅。

下边解读一下：

这个条文是经方里论述治疗原则的一个典范。真正的经方理论就是用这种方式来论述治疗原则的。其特点是将治疗原则隐含于具体治疗当中加以论述，而不是单独地说什么病不可、什么病可这样的。顶格排版条文的作者是用这种方式来论述问题的，这跟作者的年代有关，这本书的原型现在知道的是《汤液经》，那是什么年代作成的现在已经不得而知了，说不定它的年代会早于《内经》。那个时候的人除了水平和智商之外，还有一个就是一定要用最少的字去论述更多的问题。所以在一个病的具体治疗论述过程当中，不单单阐明了病因、病理和治疗方法，同时还给我们说了一些禁忌和治疗原则。应该从两

方面理解：一个方面，确实不太好理解，就是读懂的难度大一些；从另一个方面说，也确实非常精妙，能正确地理解了以后，就会发现这种写作手法非常高明。

“伤寒医下之”，伤寒本来应该汗解的，“下之”肯定就是误治了。

“续得下利”，就是说以前是太阳病，误下了以后，就接着出现了下利的症状。

“清谷不止”，“清谷”就是大便里边有没消化的食物；“不止”再加上上一句就是下利不止了，而且是大便里带有没消化的食物。“清谷”中的“清”字是一个多义词，意思很多，字典没有这个地方应该有的意思，“清”字在这应该是排泄、排便的意思。字典里会有一个厕所的意思，这是比较接近的。“清谷”就是排泄物当中杂有未消化的食物，就这么个意思。

“身疼痛者”，在这儿应该理解为表证仍在。经方里常常用某一个具体的症状来代表哪一类的疾病。比如说“不呕”指的是没有少阳病；“不渴”指的是没有阳明病。至于表证呢，论述的方式比较多，有时候用“发热”来代表，有时候用“身热不去”来代表，有时候用“仍发热”来代表，有时候用“头疼”。这地方用了一个“身疼痛”。之所以有这样的区别，都有用意的，大家看前边四逆汤证里边，就讨论到了一个“身疼痛”的问题。应该说在临床中，凡是有阴性里虚寒证再有表证，可能表现为“身疼痛”的机会就比较多。但是我们今天理解不能机械地去套，可以综合地去看，有表证就是有表证，没有表证的也不能误诊。到这儿，它论述的是伤寒经误下后又发生了里虚寒证，同时表证也还没有消失这么一种情况。

下面就给出了具体的治疗原则和治疗方剂。

“急当救里，后身疼痛”，这就是治疗原则了。指的是一旦出现这种外有表证，里有虚寒证的情况，就得先治疗里虚寒证，然后再解

表。这儿本身就隐含了经方对人体的生理、病理和辨证体系的诠释。里虚寒证的实质是什么？就是人体以消化道为主的机能低下，甚至沉衰的疾病。人体的消化道是给人体提供能量最主要的一个来源，但是它出现了“下利清谷”的机能低下，都不能消化东西了。实际上这就是经方的病理辨证。发汗解表是一种攻法，会大量地消耗人体的能量，所以在有里虚寒证的情况下（里虚寒证就是能量来源就不足了），先要解决人体能量来源的问题，就是先要去治疗里虚寒证。大家看看这是不是经方对病理的诠释啊？实际上就是讲的人体的生理特点、病理特点。

“清便自调者，急当可救表”，这一句可以做两种理解，本身就包含了两层意思：第一种，上边所讲述的这类情况，如果服了四逆汤后里虚寒证消失了，里虚寒证消失的标志就是“清便自调”，也就是二便正常，这个时候才可以再解表；另一种解读，上边论述的这种情况，如果服了泻下药之后并没有发生里虚寒证，“清便自调”，可以直接去解表。因为有下在先，其他的解表方剂不能用，应该用桂枝汤。

下边给出了具体的治疗方法：“救里宜四逆汤，救表宜桂枝汤”。这两个方剂都用了“宜”，而没用“主之”，本身就暗含有可变通的余地。具体说，如果没有阴证的话，只是下利清谷，理中汤也能解决了。所以说应该有变通的余地。

但是这里应该强调的一点，“宜桂枝汤”并不是所有的发汗剂都行。按照经方的治疗原则，泻下以后就没有应用麻黄汤的机会了。就是一直没有汗出，也没有应用麻黄汤的机会，都得用桂枝汤类的方剂。如果表证陷于阴证的话，也可能用到桂枝加附子汤之类的方剂。

我们再延伸一下，像这一类的情况是不是可以同时治呢？比如既有里虚寒，又有表证。同时治行吗？也有有这样的例子，比如桂枝人参汤就是一个典型的例子，既有里虚寒又有表证。但是，这儿之所以强调分开治，是因为里虚寒证又重又急的话，肯定得分开治。

做个小结：伤寒病，医生反以泻下的方法给予治疗，于是出现了下利不止，且排泄物中杂有不消化的食物，如果同时还有身疼痛的，应该先治疗其里证；当二便正常，里证消失后，再治疗表证。里证宜用四逆汤类方剂治疗，表证宜用桂枝汤类方剂治疗。

这个条文是经方理论里论述治疗原则的一个典范。为什么这么说呢？大家再品味下学过的条文，这个条文用的文字少得不能再少了，但是它论述的问题是很重要的，论述的问题反倒是很多。咱们集中一下大概有这么几个要点：

第一个，说明了伤寒不可下。如果合理的延伸就是表证都不可下。这是一个禁忌，下了以后肯定出事。

第二个，一旦误下了有可能造成阴性的里虚寒证重证。当然还可能造成其他的证，甚至造成阳明病也有可能。这个地方说了临床中有因为伤寒误下造成里虚寒证的病人，也许病人以前就有这方面的倾向。如果延伸一下的话，不仅仅是一个四逆汤证的问题，比如白通汤、通脉四逆汤、理中汤都可能有应用的机会，看病人具体的症状表现了。

第三个就是外有表证，里有虚寒证不可单独发汗解表。这儿就是强调的治疗原则。尽管条文里没有不可怎样怎样的字眼儿，但是里边确实确实有这个意思，很明确。外有表证里有虚寒证的时候，后者为主要矛盾，也就是说先治里虚寒证，后治表证。这也是个治疗原则，在条文里强调的非常明确。

还有一个，表证误下后，如果没有发生里证的（也就是条文里说的“清便自调”的）仍然可以解表。但是别的条文里论述了不能用麻黄汤解表，要用桂枝汤。再看一旦出现阴性里虚寒证，就要用四逆汤类方剂治疗，给了具体的治疗方剂，也不是随便给一个方剂就拉倒的。一旦出现阴性证，你再用理中汤就治不了了。

如果再详细从这个条文里往外提强调的意思，还有很多。随便拿“清便自调”，就等于说没有里证的一个很重要的标志。我们在辨证

当中问大便，目的是什么？就是看看有没有里证。

病发热头痛、脉反沉者□□^①若不差、身体疼痛、当救其里、宜回逆汤^②、^③（92）

注：

1. 《宋本》无此二个缺字符号。
2. “宜回逆汤”《宋本》作“四逆汤方”。
3. 《宋本》此处有四逆汤方及方后注，此从略。

胡希恕：应该“宜四逆汤”，应该有个“宜”字。在成无己本上就是“宜四逆汤”。应该有个“宜”字，不是“四逆汤方”。这是前后没有回文，不衔接了。”病发热头痛，脉反沉，若不差，……”很含蓄啊，这个咱们可以看看少阴篇，这就是从少阴篇这节来的，麻黄附子细辛汤。我看看多少节，哦，301，你们看看，少阴篇 301 这一条，“少阴病始得之，反发热，脉沉者，麻黄附子细辛汤主之”，它是根据这条来的，少阴病也在表嘛，他开始得的时候，这个少阴病啊，以不发热为常的，脉也不沉，所以这个少阴病，在太阳篇头前就有，“病有发热恶寒者，发于阳也，无热恶寒者发于阴也”，发于阳就指着发于太阳病，发于阴就指着说的发于少阴病，所以这个一般感冒也有的，所以在临床上要注意，它就来了，不过这个少阴病少见，身体素虚或者是老年人，他开始得病就是少阴病，这个体温呢，病人不觉得发热，你要试温，体温也挺高的，所以这个发病开始，不发热，只恶寒，所以大概有少阴病。那么这个呢就是，少阴病始得之，反倒发热，本来以不发热为常，而反发热，脉一般也不沉，而脉反沉，这说明什么问题呢？这就是表证内有停饮。

这个沉啊，《金匱要略》上有，脉得诸沉，当责之于水，里有水，脉就现沉。那么少阴病这个病啊，又里有水，这个少阴病维持在表的

期间最短，就是两三天，他如果里头有水一传里，非传到太阴不可，所以这个时候啊赶紧去饮，他搁细辛嘛，细辛也是主水饮的一个药，所以小青龙汤里头也搁细辛嘛，我们这一段就是接着这来说的，“病发热头痛，脉反沉，”就指着这个“少阴病始得之，反发热，脉沉者”，就指着这段。”若不差”，就是服了麻黄附子细辛汤，而病还不好，”身体疼痛”，身体疼痛还可以有表证啊，可是有表证，已经吃过麻黄附子细辛汤，而脉沉，不愈呀，那么说明不能再发汗了，少阴病更不像这个太阳病，那么这也得赶紧救里了，温其里以去其水饮。由于这个少阴病要转入太阴，这个死亡率相当地高啊，所以近来，大家留心老年人得感冒死亡的非常地多啊。这个要得少阴病这种感冒，传里而并发太阴病的时候，死亡率相当地多。所以这个时候，得了麻黄附子细辛汤证而脉沉，还主为里，虽然有表证，这个里头阴寒太盛了，赶紧舍表救里，或者是个当救其里呀，这根据上一条啊，当然也有四逆汤，这个地方都很好。不过这个一般注家都搞错了，他没前后看，他觉得若不差，你看这个书上的不解呀不差呀，都有用意的，不是随便搁这么两个字，随便搁两个就没意思了，象这个头痛发热，脉反沉，他搁个若不差，什么意思啊？若不好，在这就讲不通了，就是根据那一条（301），他说“病发热头痛，脉反沉”，不应该脉沉，它是表证啊，由于里头有停水，里头停水有时候胃虚才停水，也就是虚寒，一方面要解表，依法呀，根据那一条，同时要用细辛去其寒饮。那么吃这个药还不行，这个阴寒太深，得赶紧舍表救里，它是这么一个。所以这一段根据字面讲，讲不通。

那么四逆汤头前讲过了，就是甘草、干姜、附子，甘草干姜汤加附子，这是温里最有力量的药了，后头说的温里回阳啊，其实就是温里。

李冠杰：“病发热头痛，脉反沉者（这儿，《康平本》里有两个缺字符），若不差，身体疼痛，当救其里，宜四逆汤”。那么，在这

个条文后边，《宋本》有四逆汤方剂和方后注，《康平本》没有。

这个条文里的“宜四逆汤”，在《宋本》里是“四逆汤方”。这个“四逆汤方”，显然是抄写过程中出现问题了。因为四逆汤方不属于条文里边的内容，是下边方剂的方名。这个肯定是《宋本》在抄写的过程中，不管是哪个时期，抄的人精神不集中，把下边的方名抄到这个地方来了。而且如果说细品，很有意思，这个地方怎么会出现一个方名呢？因为在《康平本》那个时期是没有方子的。到了《宋本》时候，要在这个地方加上方子，为了读着用着方便。把别的地方的四逆汤方子加过来，就在调整过程当中，不知出现什么过错，就出现了这样的差错。

这个条文是降一字格排版的条文。应该是出自张仲景之手。

这儿有一个很重要的事，我们必须闹清楚。就是这个条文里边的两个缺字符号，到了《宋本》里边就没有了。这显然能看出一个事儿来，就是王叔和在第一次整理《伤寒论》的时候，态度是非常严谨的。就是缺字的地方，我看不清的那个字，用一个缺字符加在那个地方，我也要保持原来的样子。但是到了第二次整理的时候，他不单单把这一部分内容全部去掉了，而且把所有的注解文字也都篡入正文了。大家可能会说，你怎么能把这么大一件事扣在王叔和身上，那么会不会是宋代的校正医书局里边的人这么做的。这个事儿可能性不大，因为，宋代的校正医书局的人他们在校正的过程当中，尽可能地保持原有的样子。而且他们改动的，他们自己加上去的東西，好多，甚至于像刚才的“四逆汤方”，如果他们想动的话，那个东西就该动，因为它不是一个地方出现这样的情况，而且像在条文里面说到“四逆汤方”这样的说法，绝无仅有，就这一个。所以说这是一个错的，明显能看出来是错的，他们都没改。所以说他们绝对不会做这么大幅度的改动。现在我们知道的，只有王叔和一个人才可能会做这样的更改。

那么我们解读一下：

“病发热头痛”，这是指的患者就诊时两个主要的症状反应，相当于我们今天病人的主诉。但是，这里边有个问题。这两个症状，虽然说看似典型的表证的症状，但是仅凭这两个症状，你还不能判断成表证。它在很多的其它类型疾病里面，都有可能同时出现，你比如说太阳病里边，这个没说的；少阳病里边，发热头痛也是常见症状；阳明病里边，发热头痛也是常见症状；少阴病里边，也可能存在，你比如说麻黄附子细辛汤就有可能出现发热头痛；甚至太阴病里边，也有可能出现这一类的症状，都有可能出现的。那么你不能单纯的从这两个症状来断定疾病，再看看其他的症状。

“脉反沉者”，那么也就是说，发热头痛，以表证为最常见。前边呢就有这么一个意思，病人说他自己发热头痛，马上想到了表证。但是呢，你要是看看脉，表证呢，通常应该是浮脉的机会比较多。但是呢，这个病人却表现为沉脉，所以这个地方用了一个“反”字，“脉反沉者”。暗示其中可能有存在着其他的疾病。

下边，这个地方《宋本》就没有了，你要是读《宋本》或者读其他的版本，这一类的信息你是永远得不到了，就不可知了。只有咱们今天能看到《康平本》我们才能知道这个信息，两个缺字符，“某某若不差”，这两个字应该是什么字？就这个地方，我反复地看了若干遍，后来我个人的认识，因为现在像我们这样这么详细地一点一点地去抠这个《康平本》的，还很少，所以咱这也没有其他的资料可借鉴。那么这两个缺字符是什么？我认为是“发汗”这两个字，这纯属我个人的见解，大家可以去看。那么它的意思是什么呢？意思就是说，条文你这么地往下读啊，你初看这个病人，“发热头痛”，他这个症状颇似太阳病，那么你就给他发汗，但是他脉还现沉脉，就是说你发汗以后，他反倒是病没有好。那么怎么知道病没有好？

后边说，还有身疼痛，说明他还存在着其他的病，不仅仅是表证。“脉反沉”指的就是这一类的意思。这样整个前后都能对起来了。

也就是说这个条文，你看着他像表证，但是呢，脉有点沉，发汗试试吧，发了汗以后，病并没有好，顺理成章嘛，因为他这个脉沉本身就候着他有别的病，他不单纯是表证了。但是你这个汗却发了。这种情况下，其实后边这些就比较容易理解了，跟前边的条文基本上是一个意思。看这个样子，这个人本来就有里虚寒证，你给他发了汗以后，他有可能陷于阴证了，要用四逆汤来治疗。

这个条文的意义在于它对经方辨证方法做了深入的诠释。临床当中不同类型的疾病之间，在症状反应上，相互交错的这种情况很常见。其实我们现在，你初入经方的门，然后再去慢慢临床，遇到的最直接的问题，就是这个问题。因为你一开始嘛，你总希望病人的这个症状就是某某方证里那个证，用这个方子治了就好，那多好啊。但是实际情况不是这样。你像刚才这个头痛发热，这两个症状，别说两个同时出现，如果说一个单独出现，这种情况也是同样对待，而且更严重。因为它在很多类型疾病里面都有可能出现。那么你要怎么来辨证呢？这儿就给你一个提示，你看看，本来他就有一个沉的脉，你再发汗，他病肯定不会好的，而且这种情况下，发了汗以后，有可能成为阴性虚寒证的可能性比较大。后边给你了一个具体的治疗的办法，就是四逆汤。

下边做个小结：患者表现为发热头痛，但是反而现沉脉，发汗后如果病不得愈，仍然身疼痛的，应该先治其里，宜用四逆汤治疗。

大阳病、先下而不愈、因后发汗、①其人因致冒、（93）

注：《宋本》于“因后发汗”之后有“以此表里俱虚”六字。

冒家汗出自愈、所以然者、汗出表和故也、里未和、然后复下之、（93）

胡希恕：这个太阳病，法当汗解呀。这都根据这头一条，就是“本

发汗，而复下之”，“本先下之，而复发汗”，就根据这一条，所以呢这个治误就是逆治。太阳病依法当汗解，当发汗，那么先下，那病不会好的，“而不愈”，一看，不好，又给人发汗，这是错误的。那么太阳病误下，表不解，也不能再发汗，只能用桂枝汤，所以桂枝汤要特别记住桂枝本为解肌，我们方才也讲了，汗下之后表不解，只能用桂枝汤。他说多发汗啊都指着麻黄汤。那么这个大夫就乱来了，先吃泻药就错了，而表不解应该用桂枝汤以解肌，不应该用麻黄汤以发汗。“因复发汗”，他又用麻黄汤来复发汗了，一误再误，这个下之虚其里，发汗呢虚其表，以使表里都虚，表也虚了，里也虚了。“其人因致冒”，这头前不有嘛，“发汗，若吐、若下”，这都能够亡津液 亡血液。这个就是由于表里俱虚，人丧失了大量的体液，就是贫血了，这个”冒”，就是昏冒，就是现在咱们说脑贫血，这是一时的，不是素日贫血了，由于治疗的关系，一时他脑贫血而昏冒。“冒家汗出自愈”，那么没有其他的毛病，他一时的现象，津液恢复就好了。津液恢复，表和了就要出汗，这个就是自愈的现象。冒家汗出自愈，不是让你发汗，这个汗出说明津液已和了，营卫已调了，恢复了，津液恢复，血液也不贫了，这冒就好了。那么底下这有个解释，为什么呢？就是“汗出表和故也”。这个汗出啊，由于这个汗下失法，一时津液血液都虚，一时地眩冒发作。那么如果他要是出汗了，津液已恢复了，表和了，表和了，津液也恢复了，他这个冒就自然好了嘛，就这么个道理。如果这时候你看还没和，丧失体液太多了，那么大便也干，那么你再“然后复下之”，再和其胃，底下这一段都是接着这一段讲的。

李冠杰：“太阳病，先下而不愈，因后发汗，其人因致冒”。下边这一段同样是 93 条，在《宋本》里是一条，但是在《康平本》里是两条，而且这是两个不同的作者写的。再看看内容也确实有这样的意味。“冒家汗出自愈，所以然者，汗出表和故也，里未和，然后复

下之”。

那么在《宋本》里边，“因后发汗”之后，有“以此表里俱虚”六个字，很显然这是王叔和第二次整理的时候加上的。如果是第一次整理的时候加上的话，那是以嵌注或者旁注的形式加上的。但是他在第二次整理的时候，发现在这个地方如果加这么一个注比较好，因为他这一次整理就干脆把旁注和嵌注都篡入正文了，所以这个地方他就直接加在后边了。

咱们解读一下：

“太阳病，先下而不愈”，太阳病本来应该是发汗解表的，如果先用下法，肯定是误治了，那么病不好，这也是情理之中的，是一种常见现象。如果病好了，反倒是特殊情况。

“因后发汗”，也就是说用了下法以后，看到表证不好，才想到，这是个表证，应该用发汗的方法治疗，他就又给他施以汗法。那么按照经方的治疗原则，如果说下了以后，没有发生其他类型疾病的话，表如果说不愈，你需要用桂枝汤来治疗。但是，这儿所说的发汗，是指麻黄汤而言，所以说这儿的发汗也是错误的治疗。

这后边，《宋本》里边有“以此表里俱虚”六个字，他是对以上一再误治的后果所做的病理解释，应该说比较恰当。你看又是误下又是误汗，那肯定“表证误下，诛伐无辜”，常会致里虚；如果误下了以后再误汗，又会致表虚。所以说“表里俱虚”这个注解，应该说比较精当。

“其人因致冒”，这个就是因为表里俱虚，使人在短时间内出现“津虚血少”的这种情况，那么严重的时候就会造成“脑贫血”，发生精神恍恍惚惚这种症状，所以叫做“冒”。这个“冒”字，我也查了一下，如果说作为中医的术语，“冒”字有这么三个意思：

1. 指的是用手捂住、摀住，像“叉手自冒心”；
2. 恍恍惚惚，这是一种精神状态；

3，冲泛，像“寒饮上泛”这一类的有时候也叫做“冒”。

这一条里面讨论的肯定就是第二个意思了，指的是一种恍恍惚惚的精神状态。这个条文里边所论述的属于一种临时性的症状，你等这个人体津液恢复了以后，它可以自愈的。所以说呢顶格的作者并没有给予具体的治疗方法。

这个下面这些内容，也就说降一字格条文的作者根据自己的临床经验，根据自己的积累，他作了进一步的论述。

他说这个“冒家”，也就说像上边说的这种病人，随着人体津液的恢复，还会有一个汗出而愈的这么一个过程。为什么会出现这个呢？还作了病理上的解释。也就是他说，“所以然者，汗出表和故也”。就说表证所以能够自愈，是由于人体整体恢复以后，它达到了体表组织恢复的一个能力的这种水平，而出现了汗出表解的这么一种情况。

你像这一类的，除非有临床实践经验，才可能作这样的阐释，不然的话没有会想到去洞见这一类的东西。在这儿我们可以联想到一个什么问题？这个汗出只是表解的一个标志之一，但是，不是所有的汗出都会导致表解。你比如这个条文里面就有。他前边服过发汗的药，那么已经有过发汗的过程，但是因为有里虚，所以说能力不足，那个时候是头发汗，汗出只是损失了一部分能量，但是表解不了，反而表不得解。

后边“里未和，复下之”，那么这儿是进一步论述了属于另外的情况。那么也就说如果自汗出后表证消失了，但是他又出现了里实热证这一类的疾病，那么还可以用下法来治。但是这个下法呢，如果我们参照其他的条文的话，可以知道大概就是调胃承气汤之类的方子，就是说用泻下的轻剂。

下面作个小结：太阳病，先用泻下的方法治疗病不愈，而后又施以汗法，致使患者表里俱虚，可能发生晕冒的症状。那么这种患者，在人体恢复后便会汗出自愈。这是因为此时的自汗出是人体体表功能

恢复正常的一个标志，所以表证自然可以解除。如果此时还存在有里实热证的话，可以用适当的泻下方剂加以治疗。

大阳病未解、脉阴阳俱停、下之^①必先振栗、汗出而解、

（注）但阳脉微者·汗出而解^②·但阴脉微者·下之而解·（经）若欲下之、宜调胃承气汤、（94）

注：

1. 《宋本》无“下之”二字。
2. “汗出而解”《宋本》作“先汗出而解”。

胡希恕：这个就是接着那一段，本来是太阳病，先下而不愈，因复发汗，这个太阳病还未解，这个未解也不是随便搁个未解呀，本来就是太阳病，“脉阴阳俱停”下来就完了呗，搁个“未解”干什么呢？他要澄清这么个道理，就是汗下失法而太阳病还未解。那么这时候看他的脉，“脉阴阳俱停”，阴阳啊就是外以候阳，里以候阴，脉阴阳，咱们在太阳中风头一条就讲了，“阳浮而阴弱”，浮取这个脉就是候其阳，沉取其脉就是候其阴，那么浮沉这个脉“俱停”，咱们说这个停停当当地，停停当当，就是没有什么偏差，就是脉无论浮取，无论沉取，脉都停当，也可以说都挺宁静，这就是阴阳自和了，那么这个“发汗吐下后，阴阳自和者必自愈”，就是表里内外没有什么特殊的情形，这个脉也阴阳自调，这个停不是停水那个停，有的给解释错了，说有停水，那是怎么成自愈呀。这个古人有这么一个讲法，停停当当。

“必先振栗汗出而解”，那么这个暗含着也有这个“冒”啊，就是头前这个，这个我们看看《金匱要略》就有这个，所以亡失体液太多就那么病。那么这个病还是没好，但是这个脉呢阴阳自调，”必先振栗汗出”，这是什么意思？就是津液恢复了要自汗出，但是必先

振栗汗出，振栗汗出就是咱们说的战汗，那都是冥眩状态。所以有病或者是误治之病，这个人虚了，如果要是治愈的话呀，要发作冥眩，他恢复的时候，本来津液恢复要出汗的，但是这个出汗以前要颤抖，战汗，打寒战，振栗，打战战，然后复以大汗，好了，这是说这个脉阴阳俱停。

“但阳脉微者”，这个微也不是脉微欲绝这个微，这个微当作弱字讲，阳脉微者就是浮弱的脉，浮缓浮弱的脉。浮缓浮弱还是在表嘛，就是桂枝汤证。但是这个脉不象有毛病了，它是脉浮但是弱，这不是太阳中风脉嘛，桂枝汤证了，“先汗出而解”，这个不是自愈的样，得让人再出汗，用什么法子？用桂枝汤。这是在言外用桂枝汤了，书上没有写，但是我们要理解。

“但阴脉微者”，浮取没问题，脉沉而缓弱。那么仲景这个脉呀，浮缓为中风，沉缓为亡血呀。咱们开始讲太阳中风，“阳浮而阴弱”，阴弱，你使劲按，脉内不禁按，那血少。这个血少那是里不和呀，这个书这是简略，那么怎么个里不和呀？就是胃中干，胃有热，丧失人的阴分，所以按着缓。但是在临床上我们不能根据这一条，你总是要问的，这个人口干啊，大便秘结不通啊。他的书可都没提，但是我们在临床上也不能光凭脉，必须脉证结合起来看。那么一般上说，根据这一条，汗下失法而造成这个病不解，有可能脉浮缓，这是个表证；脉沉缓沉弱，这是里不和，病在里，一般说是宜调胃承气汤。但是我们在临床上呢不能说是遇到一个沉缓的脉，不问证候就给开调胃承气汤，那是不行的，你必须要证与脉对照起来，头前这个也是，脉浮缓，也得有证候，他这个没详细说，这是个略笔，这一段接着前一段。

李冠杰：这条在《康平本》里是顶格的条文。但是中间呢，包括了嵌注内容。条文中的“下之必先振栗”，在《宋本》里“下之”两个字没有，也就是说改成《宋本》的时候，第二次整理的时候把它去掉了。这个嵌注中的“汗出而解”之前，《宋本》里有一个“先”字，

它应该是为了呼应前文插的，因为前面有个“先振栗”。像这个对理解原文都没有很大的影响。

我们仔细地看，《康平本》给我们带来了很多历史当中从来没有考虑到的东西。仔细分析一下这个条文，会发现这条很可能存在了残简。依据是什么呢？

首先，上面的第 93 条的前半部分有两个脱字，说明那个地方至少有看不清的字，残缺了。比如说有虫蛀的话，那么可能相邻的地方都存在虫蛀的问题，当然不一定是虫蛀的。这是第一种考虑。

第二，如果我们把条文里的嵌注内容，把注解内容全部剔除出去，这个条文的意思明显的有不连贯。大家看一看条文就知道了，“汗出而解”后边应该接“若欲下之”，因为其他的文字是嵌注，后来又加上，挤在里面的。这就不太通顺，既然“汗出而解”为什么还要“若欲下之”呢？这儿有可能本身不连贯，可能存在有残简的问题。

第三个，这个嵌注内容的加入说明什么？加嵌注的这个人看到的几乎是书的原稿，如果原文出了问题，他自然会感觉到有责任把内容补全了，给加一个注。这个地方本来应该有字，但看不清是什么了，那么按照我的理解加个注吧，这也是很自然的事。

我们今天是通过《康平本》和其他版本的对照，发现了这些问题。我们也就只能按照今天见过的《康平本》这种格式来学，因为它给我们携带的信息最多，而且也最接近于书的本来面目。我们就只能按着《康平本》来学。

下边解读一下：

“太阳病未解”，“未解”不是随便写在这儿的，它暗含太阳病经过了某些治疗之后。是什么治疗不重要，这里边包括了治疗的意思，不然没有必要写不解了，直接写太阳病就行了。因为经过了治疗没有好，也许是合理的治疗，也许是不合理的治疗，反正病还没有解。

“脉阴阳俱停”，《中医辞海》上没有对“停”字在这个地方的

意义解释。在字典上这个“停”最接近于这个地方的意思，能够跟这儿接轨的就是“停当、妥贴”的意思。再来看看这个脉，“阴阳”分别就代表了阳脉是浮取，阴脉指的是沉取。就是说脉不管是沉取也好，还是浮取也好，“俱停”，都很停当，都很妥贴，也就是基本上接近于平脉，或者直接可以理解成就已经是一个平脉了。

这个时候，下面“下之必先振栗，汗出而解”，如果说医生看表还没解，他感觉那个药挺对症的，为什么不好啊？其实也眼看就好了，但是他等不及了，就说他没有这种经验，然后又使了下法。那么这个时候则可能出现先发生振栗，也就说打颤，然后自“汗出而解”这么一种情况。

这个地方有一个必须引起注意的，前文里面有“脉阴阳俱停”，就是脉基本上接近于平脉。说明这个时候虽然还有表证，但是已经有明显向愈的趋势。临床遇到这种情况，让他多喝点水，多休息，很快就好了，不用吃药都可以好。那么这个时候如果再用下法，就为误治了。但是因为人体已经有基本病愈的趋势，如果用轻度的泻下的话，有时候也不至于造成新的疾病发生，但是一定可以降低人体的抵抗力。所以说病还可以痊愈，但是痊愈的过程会表现为比较强烈的反应，人都打颤，最后才能汗出。

就算是这样，我想也应该具备几个前提条件才可能出现这类的情况：第一个，这个人平时身体相对比较健康；第二，一开始得了太阳病的治疗方法，对人体没有产生实质性的伤害，或者说是基本对症的治疗方法；第三，这个下之所用的方剂必须得是泻下轻剂。要用大承气汤的话，一剂下去就别再指望自己恢复了，汗出表解那是不可能的了。

下边是嵌注内容：“但阳脉微者，汗出而解，但阴脉微者，下之而解”。加这一段嵌注内容的用意在于为下边的“若欲下之”衔接，前边已经汗出而解了，为什么还要下之呢？他就在中间做一个承接，

做了逻辑上的解释，并且提供了临床上的依据，临床上出现这种情况的时候可能需要下。

那么作者想说什么意思呢？既然是已经达到了汗出而解，那又何来欲下之呢？他认为这其中至少应该存在两种情况：“但阳脉微者”，“微”在这里应该理解成缓弱的意思，就是说脉浮取有缓弱之意，实际上就偏离平脉了，不能算“脉阴阳俱停”了。这个时候说汗出而解，我们也可以这样理解，也有用桂枝汤发汗的机会，当然也有可能自己自汗出，本身就包含有这样的意思。第二种情况是“但阴脉微者”，也就是说脉象上沉取现缓弱的一种脉，这个时候按照后边衔接治疗方法来说，应该是里有津液虚损，或者是胃中津液不足。前边条文里边论述过了“胃中干”这类的情况，所以说下之而解。但是在临床中真正如果沉取脉微弱、缓弱之类，就是有可下之证，那也得非常小心，至少调胃承气汤少给，可以在量上控制下。

“若欲下之，宜调胃承气汤”，这里我们还有另一种理解的方式，就是把嵌注内容撤掉，直接把它接在“汗出而解之后”，因为它和那篇文字之间是不是缺少了文字，我们现在不得而知了，但是从顶格条文，我们应该这么理解。那么这个条文的意思就成了：太阳病，经过治疗没有痊愈，脉已经趋于平脉，又施以下法，之后出现了振栗、打寒战，而后汗出而解，表解了；如果这个时候尚存在有里实热证的话，则需要再用下法来治疗，治疗的方剂就用调胃承气汤。这样似乎也有点通，但总是让人感觉字面的意思不够连贯。

做一个小结：太阳病经治疗后表证未解，但脉阴阳俱停，如果见仍有表证而误用下法的话，则可能致人发生振栗，而后汗出表解；此时如果又出现了可下之证的话，宜用调胃承气汤治疗。

大阳病、发热汗出者、此荣弱卫强^①、故使汗出、欲救

邪风者、宜桂枝汤、（95）

注：“此荣弱卫强”《宋本》作“此为荣弱卫强”。

胡希恕：这本来是太阳中风重出了，他主要是让你认识脉的阴阳候愈的问题。“发热汗出者”，太阳中风证，太阳病，发热汗出，这是太阳中风证。他搁个“此为荣弱卫强”，你们看看头前那个太阳中风，“阳浮阴弱”，阴就指着荣，阳就指着卫，那个是阳浮阴弱，这个搁个荣弱卫强，这是互词，他是特意让你在这明白，我们说的阳浮阴弱，也是卫气向外，他在底下解释好了，“阳浮者热自发，阴弱者汗自出”，这个营之所以弱，由于汗出，或者汗出于营啊。那么这个卫不共营协调往外跑，所以它强，脉也浮，这个就告诉你阴阳，所以在《金匱要略》上有的，他说是“浮缓之为中风”，我们轻取脉浮，这是中风脉，沉缓则为亡血，就是浮而缓弱，就是太阳中风的脉。那么就这两个分开呢，外以候卫，内以候营。就是脉的阴阳，要不搁这一节没有用啊。搁这一节就告诉你，营卫诊法就是阴阳，就是轻取沉取而已。

那么这是太阳中风证，那么这一节也是说上面一节“脉阴阳俱停”那个阴阳的问题。在这他又重申阴阳以候营卫的问题，要不然的话，搁这一节就一点意思没有，就是重复太阳中风证嘛，发热恶寒，阳浮阴弱。

李冠杰：这个条文在《康平本》里是降两字格的条文。条文中的“此荣弱卫强”在《宋本》里边是“此为荣弱卫强”。

咱们解读一下：

这个条文重在解释桂枝汤证的病理。“太阳病，发热汗出者”，就是指的桂枝汤证而言。

“此荣弱卫强，故使汗出”，这是作者对桂枝汤证当中汗出这一证的病理解释。但是，站在我们今天的角度看，如果写成“荣卫不和”，似乎更合理。这个荣弱卫强解释起来比较牵强。

“欲救邪风者”，这不仅仅王叔和有这种说法，大概在顶格条文个别的地方也有此类的说法，也就是说这是古人对病因病理的错误认识，不太对。

比如将桂枝汤证称作中风，把治疗桂枝汤证的过程称为“欲救邪风”，也未尝不可。但是真要把它理解成是真的风中于人体，那就和事实不相符了。还是以桂枝汤为例，临床当中有真正着了风以后患桂枝汤证的，但是更多的，并没有着风的经历，也患桂枝汤证，那你作何解释啊？要再按照牵强那种解释，什么时间，包括什么冬季的风伏在人身上，什么时候发作那就更没有什么道理了。

凡是疾病都有外界因素和内在因素这两个方面，不要片面地去认识这一事物，大多数情况下，人体的内因才是矛盾的主要方面。

我们简单地举个例子，历史上发生过很多次严重的传染病，但从没有任何一个传染病是所有的人都死掉了，要是那样人类就传不下去了。总是在传染病的时期，一部分人得病，但是同样是生活在那种环境下，一部分人并没有得病，实际是大部分人没得病。说到这儿，大家很自然都会想到，没有被传染的人，至少在对这种传染病的抵抗力要强于其他人；反过来被传染的，就是免疫力不足的问题，所以不能把所有原因都归结到传染病源上去。从这儿，我们也可以看到现代医学对这些的认识也是比较片面的。

所以说，所谓“风中于人”这样的说法，根本的原因我们应该把它理解成人体适应自然环境的能力不足所致，这才是根本的原因。

下边做个小结：太阳病表现为发热汗出的，为荣卫不和所致，治疗宜用桂枝汤。

伤寒五六日、中风·往来寒热、胸胁苦满、默默^①不欲饮食、心烦喜呕、或胸中烦而不呕、或渴、或腹中痛、或胁下

痞硬、或心下悸、小便不利、或不渴、身有微热、或咳者、
小柴胡汤主之、（96）

注：“默默”《宋本》作“嘿嘿”。

柴胡半斤 黄芩三两 人参三两 半夏半升洗 甘草炙
生姜切各三两 大枣十二枚擘

右七味、以水一斗二升、煮取六升、去滓再煮取三升、
温服一升，日三服、

若胸中烦而不呕①、去半夏人参、加枳实一枚、若渴
者②、去半夏、加人参合前成四两半、加枳实四两③、若腹
中痛者、去黄芩、加芍药三两、若胁下痞硬、去大枣、加牡
蛎四两、若心下悸、小便不利者、去黄芩、加茯苓四两、若
不渴、外有微热者、去人参、加桂枝三两、温覆微汗愈、若
咳者、去人参大枣生姜、加五味子半升、干姜二两、

注：

1. “若胸中烦而不呕”《宋本》作“若胸中烦而不呕者”。

2. “若渴者”《宋本》作“若渴”。

3. “加枳实四两”《宋本》作“枳实四两”。

胡希恕：这个头前讲了，也有病的转变，都是一个误治。那么太阳伤寒也好，中风也好，在五六天的时候，这个病一般地说要由表传入半表半里，他说“伤寒五六日，中风”，不是太阳伤寒五六日了又中风的，不是的，五六日呢有个逗点，他说伤寒五六日，或者中风五六日，他这个口气呀就是无论伤寒和中风，在五六日的时候，一般这个病要由表传入半表半里，这一般是这样的。

“往来寒热”，这个太阳病啊是发热恶寒，尤其恶寒为“必恶寒”嘛，发热与恶寒同时发作。这个阳明病在里头，是不恶寒但发热。这

个半表半里呢，是寒热交替出现，“往来寒热者”就是寒往热来，热往寒来，交替出现。那么这个道理呢，后面要讲的，现在先不说这个所以然。那么就这个寒热来分析呀，表与半表半里有这么些不同，发热恶寒太阳病，不恶寒但发热这是阳明病，往来寒热，这个热型啊也不一样，根据热型啊也能辨太阳、阳明、少阳。

“胸胁苦满”，胸、胁，这个半表半里的部位呀，就在胸腹的两个腔间，胸腔、腹腔，就在这个大部位里，那么外接近表，内接近里，胃肠也在胸腹腔间啊。那么这个地方有邪气结滞，所以胸胁苦满，就是胸胁这个部位，苦满，就是以满为苦，当作苦，劳苦，意思就是苦于劳动。

“默默不欲饮食”，“默默”，在这个地方就是昏昏然而不愿意吃东西，这块有热，这个热郁于胸腹腔间，头昏昏然而不愿意吃东西。

“心烦喜呕”，凡是热都往上炎，这个火往上来，所以这个胸腹腔间有热呀，这个热也是容易波及到心脏，心烦。那么这个热呢，也能够激动胃肠的，胃肠啊尤其这个胃，是水谷之海了，那么激动这个里水里饮，他要呕。

那么这四个“往来寒热”、“胸胁苦满”、“默默不欲饮食”、“心烦喜呕”，这是柴胡四证，这是柴胡汤应用的四个主要的证候。那么底下有些或然的证候，这说明什么意思呢？就是半表半里的部位，是诸脏器的所在，如果这个地方，这个邪热郁结在这个部位，能够影响很多脏器，失去常度的，就是失去正常而有证候的反应，所以这个相当复杂。”或胸中烦而不呕”，一般是要心烦喜呕，如果这个热不太重，只胸中觉烦热，心中不烦，也不激动里饮，所以不呕，这个是比较轻，这个邪热轻，也或者是胸中烦而不呕。“或渴”，渴，咱们都知道了，渴属阳明呀，那么这个热移到胃上，那就要渴。“或腹中痛”，腹中就是胃以下肠子，涉及到肠子了，那肚子疼。“或胁下痞硬”，这个胁下就是两侧了。痞，有痞块谓之痞了，痞是不通了，

痞块也是的，硬，从这个硬上说是痞块了，有肿结的地方，这就是肝和脾了。那么涉及到肝脾而胁下要痞硬，所以这个小柴胡汤，柴胡剂，我们治肝病常用的。这个人的胃有停水嘛，他又不渴，但是身上有微热，这头前他都讲了，所以小便不利，内有停饮，表不解，表热不除。“或咳者”，或及于肺，那他就要咳嗽，总而言之，只要四证俱在，这些或然的证候无论有或无，都用小柴胡汤主治之。

那么这个方后呀弄这些加减都是错的，这都要不得，所以这个书啊可以说是，谁出的咱们也不知道，但这里头绝对是不对的。那么这个方剂呀咱们看一看，柴胡这味药在《神农本草经》上只是说它味苦平，苦不大苦，平，不是象黄连那个苦法。微寒，它是一个寒性解热的药，苦味、寒性解热的药。那么它主治什么呢？《神农本草经》上说是主治心、腹、肠胃间结气、积聚，就是心到腹，肠胃之间的结气，或者是有积聚。结气，无形的东西才能结滞，那么有形的就是积聚，成痞块的东西，寒热邪气它也治，它能解热嘛，推陈致新。在《神农本草经》上就这么几句话。那么结气也好，积聚也好，都是在心腹这个空间，所以它治胸胁苦满，那么在仲景这个书上看是治胸胁苦满。那么根据《神农本草经》上的证候分析呀，也是绝对有胸胁苦满。那么柴胡与黄芩为伍，黄芩治烦呀，那么这两味药都是解热，去烦。

底下一系列的药都是健胃的药，这个半夏、生姜，这是小半夏汤，能够逐饮止呕的，柴胡证里头常有呕的，这个呕因为什么呢？因为胃虚呀，搁人参、甘草、大枣，补中健胃，所以这个方，小柴胡汤既是一个健胃止呕的药，也是一个解烦去热的药，那么据论还有一个说法，小柴胡汤妙就妙在人参，这也可以解释一下，为什么这个病要传到半表半里呢？这个我们得回头研究那个太阳病。这个太阳病阶段啊，人的这个机体，就是人体呀，打算由表来解除疾病，我们开始讲的时候就介绍了，邪气交争于骨肉呀，外邪、人的精气在骨肉这个地方交战，到四五天的时候，没有机会从体表解除疾病，那么怎么没有

机会了呢？就是正气不足以驱邪了，主要的是由于里虚，就是胃虚呀，那么这个时候柴胡、黄芩是能够解热驱邪的，但是里虚呀，这个病只能由半表半里再往里来，所以必须要加强正气，所以这个时候用人参是对的，徐灵胎老先生还是看得挺清楚的，小柴胡汤妙就妙在人参，这个时候不能够在第一道防线，退到第二道防线了。退到第二道防线，你正的力量没有增强行不行，还是不行的，所以这个时候搁人参，健胃，咱们说是补中益气了，这就是补中益气，那么这个时候才能发挥柴胡、黄芩的力量，才能去邪呢，主要是这么个问题。那么下面这一条，就说明这个问题。

李冠杰：这个条文在《康平本》是顶格排版的条文。

下边咱们解读一下：

“伤寒五六日”，这个“伤寒五六日”，并不是指的一个具体的日期。在经方里经常用这样的方式，通过不同的大概的日期数，来论述疾病发展的规律。我们应该怎么理解？就是经方理论的这些奠基者、作者通过总结，发现患了太阳病以后，如果得不到及时合理的治疗，常常在五、六日的时候会发展为少阳病，有这样的规律存在。但是，不是所有的太阳病治疗不当，或者没有合理的治疗，一定往这个方向发展，并不一定。实际临床当中呢，少阳病或者小柴胡汤证，往往不是从太阳病发展过来的，直接得少阳病的大有人在，有得是。实际上现在，一个人患了感冒治不好，就发展成“胸胁苦满、往来寒热”，这样的病人见到得不多。如果整体解读经方理论的话，患太阳病的日数，太阳病不是准在哪一天就会上了哪儿；而且太阳病的发展方向也不是一个。有自愈的；有保持原来状态的；也有进一步发展为其他类型疾病的。

这个地方讨论的就是：太阳病经过五、六日，经过失治以后，发展成了少阳病，是其中的这么一种。

下边呢“中风”，“中风”这两个字应该是后人加的旁注。但是，

旁注加在这个地方，非常得精妙！如果把旁注和原文综合起来理解的话，少阳病完全可以在阳性表虚证的基础上发展而来。这样就把“伤寒”拓展为了整个的太阳病。也就是说阳性表证，五、六日之后，就有发展成为少阳病的可能，更进一步准确地表述了经方理论对疾病发展规律的认识。

下边是具体的症状：“往来寒热”，指的是“恶寒”与“发热”交替而作，日发一次或者数次的一种症状。少阳病在临床当中的表现比较多，情况也比较复杂。比如：有的人感到身上就像泼上一层凉水一样，淅淅溜溜（哆哆嗦嗦）地冷一下，过一会就好了，一会儿就过去了，实际上这也是往来寒热的一种。这个症状是阳性半表半里证（少阳病）的一个典型的症状反应。虽然不是少阳病独有的，在其他类型疾病里边也有，但是，出现在少阳病的几率最高。

那么“往来寒热”的机理是什么呢？少阳病是介乎于太阳病和阳明病之间的一种疾病，所以叫阳性半表半里证。太阳病（阳性表证）是以“发热、恶寒”为典型症状反应的；而阳明病（阳性里证）则是以“发热、不恶寒”为典型症状反应，就是“但热不寒”。人体得病以后，人体抵抗力的增强或减弱不是一个直线性的过程，不是。实际上人体的抵抗力随着人体节律的变化，表现为时高时低。这是人体的节律，而且个体不同，节律也会不同。这种节律的变化，在半表半里证的时候，当人体偏于表证的时候，就会“恶寒”；当人体偏于里证的时候又会“不恶寒，但恶热”，就是感觉热。表现出一个“往来寒热”。“往来寒热”就是恶寒和恶热交替出现的这么一种症状。但是在实际临床当中，“往来寒热”在发生的顺序上一般都是先寒后热；在寒热的程度上，多数是热重寒轻，极少数是寒热并重；在持续时间上，表现为恶寒的时间短，发热的时间长；在昼夜变化上，一般为昼轻夜重，或者早晨轻，下午傍晚比较重。

但是在这个地方，有一个概念必须跟大家再次强调：经方的表、

里、半表半里，所界定的是不同性质的疾病所表现出来的症状反应。界定的是症状反应，而不是具体的病变部位。比如说，当一个患者面部发生了病变，像痤疮，就是青春痘，粉刺。同时又有里虚寒证，比如说理中汤证，那么，服了理中汤以后，随着里虚寒证的消失，痤疮也就随之而愈。这说明什么？这就说明痤疮虽然病变部位在体表，但是属于里虚寒证的理中汤证。

像粉刺，一般的治疗理念是什么呀？粉刺是红色的，说明是有热，粉刺长在体表上，肺主皮毛，就是说肺里面有热，所以在治疗的时候就应该用入肺经的清热的药。但是要真是碰到里虚寒证的粉刺，一点疗效都没有，根本就解决不了。因为他不是那种情况，这样一比较，那种辨证方法（实不可取的）。但是，经方要治的话，并不是说拿着理中汤去治粉刺，他得有理中汤证，要有消化不好，大便溏泻这一类的症状。咱们不能治好这一个病，就老拿着理中汤去治，那也不对，没有理中汤证也治不了，这是其一。更重要的是从这里边去体悟经方理论的实质。用这个实例，大家可以加深一下认识。另外一个，桂枝汤可以治疗胃炎，要是按病位辨证的话，好像是一个里证。但是这个胃炎患者表现出发热恶风汗出脉缓一系列的桂枝汤症状，同时又存在胃部的不适，消化不太好，你给他服桂枝汤，绝对能好。虽然他的病变部位在里，但是疾病反应表现为表虚证，用桂枝汤不单单是表虚证的这些症状消失，胃炎也随之而愈。这个问题的实质：人体在同一类型病理状态下，有可能在不同的部位发生不同性质的病变。这一点看似一个纯理论问题，但是这却是一个非常重要的问题。

下边呢“胸胁苦满”，胸胁指的是前胸和两腋下，肋骨部的总称。“胸胁苦满”就是指的胸胁部满闷不适这样的症状。但实际临床当中，小柴胡汤证的胸胁苦满在症状发生的部位上除了胸胁，还常常包括两肋的下方，有的人后肋部会感觉到满闷，甚至有时候有一点疼痛的感觉。那么这种感觉，如果用现代医学的观点来看，这样的症状反应是

哪一类的疾病表现出来的？咱们从小柴胡汤所治疗的疾病，我们可以很容易发现这一点，实际上这都是胸胁部里边的器官组织发生炎症或者是炎症的前驱反应。肺炎啊，胸膜炎啊，胆囊炎啊，如果有这类的炎症或者这类的器官处在炎症的前驱期，都会容易让人有这种感觉。可是有一个问题，你得有半表半里证，在半表半里证的情况下，这些器官出现这类症状反应；若不是在阳性半表半里证的情况下，就算得的是肝炎，他也不会有这样的症状反应。比如肝炎有可能出现吴茱萸汤证，如果肝炎出现吴茱萸汤证的话，他绝对不会出现胸胁苦满的感觉，如果出现胸胁苦满感觉，就不是单纯的吴茱萸汤证了。如果头疼，呕吐，又有胸胁苦满的话，你得用小柴胡汤合上吴茱萸汤。通过分析，大家可能就会感觉到，经方重的是症状。症状初看是最粗浅的，就是人患病以后表现出来的是症状，但是，在这些症状的背后，所反映的恰恰是疾病的实质。

“默默不欲饮食”，在《康平本》是默默，《宋本》是嘿嘿，但是意义是一样的。这个“默默不欲饮食”，实际是两个方面的症状，“默默”是一种萎靡不振的症状，就是精神不佳；而“不欲饮食”，是食欲不振，是一种里证。这里指的是因为精神方面不好，而影响到食欲，这是一个方面，同时也应该有里虚的存在。那么从柴胡剂所治疗的疾病当中，小柴胡汤所治的疾病即包括一些精神方面的疾病，同时又包括了胸腹腔间诸多脏器的一些病变。那么这也说明一个问题，说明人体的精神活动不仅仅只与大脑有关，而且与各个脏腑也存在着密切的关联，就是说人体是一个有机的整体。

这个“不欲饮食”，是消化道的一个症状，说明小柴胡汤证有里虚证的倾向。这两个证为什么古人作为一个症状说出来，放在一块来论述？就是在临床当中，他就发现了“不欲饮食”跟精神“默默”同时出现的时候，是半表半里证的概率比较高，小柴胡汤应用的机率非常得高。大家学胡老的讲座以后啊，都有这个印象，就是儿童身上出

现小柴胡汤证的机会非常得多。

我说一个自己生活当中遇到的，就是我的小孙子，他有一段时间啊，哭、闹，本来好好的，到十一点左右他就开始，你也不知道什么事刺激了他，他随便找点什么事他就要哭。而且在这之前好几天他就出现食欲不好啊，偶尔会干呕一下。这本身已经是很明显的小柴胡汤证了。这个孩子对气味特别敏感，你别说药，他就在那个卫生间门口走过去，他就想干呕。这样呢，我就让他妈妈给他往肚脐上贴小柴胡散剂，第二天，孩子就再没有闹，他妈妈感觉这药这么好，也没问，我也忘了跟她说，她就连续贴了几贴。贴了几贴出现什么情况？本来那几天非常好，突然那天早晨，孩子抱过来，脸也有点浮肿，老在吐，他自己就说头痛，我问这几天贴着吗？说一直在贴着。这是偏寒了，是吴茱萸汤证。我就拿回了吴茱萸汤，贴到肚脐上，贴上一个多时以后，孩子就逐渐地慢慢的稳定了，一直到中午以后，孩子也没有什么不舒服的感觉了。吴茱萸汤就贴了一次，孩子就能玩，能吃，慢慢就胖起来了。

小孩每次出现这个症状前几天，都会有食欲不太好，偶尔会咳嗽两声，咳嗽他就会带着有呕，但是吐不出来，干呕，一旦出现这种情况，他下边肯定要出问题了。有时候他自己也能恢复，突然那天来了个谁也不理，你跟他说话，他就冲你着急。他奶奶出去买东西，他就非得要出去不可，我说你别出去了，一会就回来了。就在这个过程中，他就跑他的房间里边，按着那些玩具啊，用脚蹬，踹啊，摔啊，又去发火。哎呀我一看，这个孩子心烦啊，喜呕啊，平时精神也差，食欲也不好。我又给他弄了小柴胡汤，我就接受上次教训，三分之二的小柴胡汤三分之一的吴茱萸汤，然后贴上，就贴了一次，第二天孩子就特乖，他见了你，都给你一个笑脸。像这类的事啊，大家想一想，常常有的家长说：我那孩子可乖了，整天不出门。他就不想想那孩子是不是没劲儿呀，身体不好啊。他还认为自己的孩子乖。但是有的孩

子呢，他的家长说我那孩子脾气可坏了，整天摔东西骂人。说不定孩子他心烦，他不舒服，说不定他就是小柴胡汤证。但是最终呢，就是因为没有这方面的常识，最终就认为这孩子脾气不好。我跟大家需要说明的是，不是凡是孩子哭闹就用小柴胡汤来治，你得有小柴胡汤证。我这儿一直跟大家说：前几天一直吃饭不好，有时候会干呕。这就是很明显的症状。经方治病就是得讲究方证对应。

下边“心烦喜呕”。这个心烦也是精神方面的症状。虽然跟那个默默有点类似，都是由半表半里的虚热证造成的，但是存在病变部位和热证程度上的不同。心烦多半是什么？多半是胸膈郁热。那么喜呕呢，喜呕实际上就是里虚或者胃中停饮造成的。

上边的四大主证，后世称做小柴胡汤的四大主证。因为什么？因为它在小柴胡汤证里边出现的频率比较高，而且也比较有代表性。

症状：往来寒热，饮食减少，口苦，咽干口渴，胸胁苦满，恶心呕吐，眩晕。

舌质：舌红（边、尖） 舌淡，绛舌，舌嫩、胖大、齿痕、瘀斑。

舌苔：白苔，其中有薄白、厚白、薄腻白、厚腻白、白滑；黄苔，其中有薄黄、厚黄、薄腻黄、黄腻、黄厚腻、糙黄。另黄白相间。

脉象：弦数，弦，弦细，弦滑。

现代应用：慢性胃炎、急慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、肠伤寒、急性肝炎、慢性肝炎、急性胆囊炎、慢性胆囊炎、胆石症、胰腺炎、消化性溃疡、脂肪肝、肝硬化、消化系统肿瘤、肝硬化、感冒、流感、扁桃体炎、麻疹、胸膜炎、肺门淋巴结肿胀、脓胸、哮喘、急性支气管炎、慢性支气管炎、上呼吸道感染、过敏性哮喘、肺炎、肺结核、原发性肝癌、肺癌、胸膜炎、肺门淋巴结肿胀、脓肺、肋骨结核、急性黄疸、疟疾、肋间神经痛、病毒性心肌炎、心肌炎、血压异常、高血压、冠心病、肺心病、风心病、心律不齐、败血症、菌毒血症、特发性血小板减少性紫癜、急性肾炎、慢性肾炎、肾盂肾炎、慢性肾功

能不全、肾病综合征、肾绞痛、尿路感染、尿毒症、遗精、阳痿、睾丸炎、副睾丸炎，腹股沟淋巴结炎、神经官能症、顽固性失眠、坐骨神经痛、感觉障碍、癫痫、美尼尔氏综合征、神经性休克、糖尿病、甲状腺机能亢进、胶原病、睾丸炎、性机能减弱、附丸炎、经前期紧张综合征、更年期综合征、产褥期精神阻碍、产褥热、女性生殖器病、附件炎、乳腺炎、乳突炎、急性附件炎、急性化脓性乳腺炎、乳腺增生、反复继发性流产、习惯性流产、耳前庭神经元炎、中耳炎、结膜炎、巩膜炎、过敏性鼻炎、全身红斑狼疮、淋巴结炎、甲亢、糖尿病、高热、低热、黄疸病、疟疾、小儿原因不明发热、腮腺炎、瘰癧等。

它所对应的病种非常得广。这就说明小柴胡汤证，本身是一个比较复杂的疾病，几乎涉及到所有的脏腑器官。表现在临床上，症状反应也相当的宽泛。除了四大主证之外，由于发病的具体的组织器官的部位不同，还会表现出一些其他的症状。在经方条文里边列举了一些或然证。

下边看看这些或然证。

“或胸烦而不呕”，这是一种胸膈郁热的典型症状。比如栀子豉汤证，往往是胸部的某些器官发生炎症的一种症状反应，或者处在这个炎症的前驱期，像心肌炎，胸膜炎等等这一类的。因为这一类的疾病涉及不到胃肠的状态，所以没有影响到胃肠，胃肠没有明显得虚的倾向。只是感觉到胸中烦为主要的症状反应。他没有呕的情况。

“或渴”这就是口渴了。小柴胡汤证是半表半里的一种热证，主症里边除了四大主证之外，还有口苦、咽干、目眩。他本身是一个热证，我们可以把它理解成咽干的比较严重的情况，就表现了一种口渴。同时可能有一点偏于阳明病，有一点里热的倾向，也会表现为口渴。

“或腹中痛”，小柴胡汤证病理状态下，腹中的胃肠等器官发生的某些病变而出现的症状反应。

“或胁下痞硬”，这个胁下痞硬，如果折成现在疾病的话，像肝

胆，脾脏、胰腺这些器官发生某些病变的时候，肠胃表现为这一类的症状。这个痞指的是胸口部位如有物堵塞，胀闷不适，按之不痛的这么一种疾患。胁下痞就是指的两胁下，不单单胀满痞塞，而且按之有硬感，就是说他有结的情况。往往是某些炎症肿瘤之类疾病的一些那个应证吧。但是在小柴胡汤证里边，胁下痞硬也好或者胁下满也好，表现为右侧的情况较多。也有像胰腺的疾病表现为左侧。要是按脏腑辨证，它没法理解经方理论，他就认为小柴胡汤是清胆热的，是治疗肝胆疾病的专方。出现在右侧可以理解，因为肝胆就在人体的右侧。实际上右侧左侧都一样，他出现的痞病有口苦，都可以认作是半表半里证，而且药到病除。作为这个方剂来说，左右胁下的痞硬或者痞满都能治。

下面“或心下悸”，这是胃中停饮的一个症状反应。

下边“小便不利”，这个小便不利本来就是体液代谢不良的一个症状反应，是停饮的一个症状。但是出现在小柴胡汤证当中，大家应该记住一个前提条件，它是急性病，不应该是长期的。急性肾炎，如果表现为小柴胡汤证的话，可以用小柴胡汤治愈。如果长期患肾炎的人，就会造成严重的体液代谢不良，真正的体液代谢不良发生了以后，就不是小柴胡汤所治的了。所以说呢，这个地方小便不利不是长期的，应该是一个急性症。

“或不渴”，这个不渴呢，就是胃中有轻度停饮的话，往往就会表现为口中和而不渴。他从偏里热，或者说半表半里热造成的口渴，一直到口中和，一点都不渴，这都是比较宽的一个症状范畴，他这儿有不渴，还有口渴这一方面的任何症状。就是不表现为口水多，也不表现为渴的，属于小柴胡汤证的都有可能出现的。

“身有微热”，也是比较典型的半表半里证的一个反应。可以理解成，比如处于低热状态的人体，有没有小柴胡汤证。

或“咳”，这个咳是在半表半里证病理状态下，呼吸系统发生病

变的一种症状反应。

条文里边举了这么多的或然证，就展示了半表半里证的症状反应的复杂性。讲到这儿，有一点必须说明，这些或然证都是在小柴胡汤证的病理状态下出现的不同的症状反应。都是小柴胡汤可以治疗的，这一点非常重要。

这个条文所讨论的病理：就是阳性的半表半里虚热证兼里虚证。无论是从方剂的药物组成看，还是从症状看，都有某种程度的里虚证。我以前的时候，给这些方剂做病理鉴定的时候，把里虚证给忽略了，应该有里虚证这一项。

下面做个小结：太阳病如果迁延多日不愈，则可能进一步发展成其他类型的疾病，如果症见往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴。或腹中痛、或协下痞硬、或心下悸，小便不利，或不渴，身有微热，或咳者，为小柴胡汤主治之证。

小柴胡汤由七味药组成，柴胡是方剂的主药，而且用药量也非常大，比其他六味药高出来一倍还要多。和黄芩同用，有很强的祛半表半里虚热的功能。《神农本草经》对柴胡是这样论述的：味苦，平，无毒，治心腹，去胃肠中结气，饮食积蓄，寒热，推陈致新，久服轻身明目益精。小柴胡汤的四大主证，都跟《神农本草经》的描述有密切的关联。比如寒热邪气，就是往来寒热，是一个比较明显的反应；特别是推陈致新，小柴胡汤所治的，涉及到五个方面所有的器官，这个推陈致新，古人总结得非常有意思。

我们再来看看整个方剂，如果将柴胡去掉，再加上黄连，用干姜易生姜，就成了半夏泻心汤。半夏泻心汤的主要功能，就是治疗消化道里的诸多疾病，也兼去半表半里的热。小柴胡汤里面包括了这么多半夏泻心汤的药物，其改善胃肠功能的作用也是非常明显的。这么多改善胃肠功能的药干什么用？小柴胡汤证本身就有里虚的倾向。小柴胡汤证是通过表证因为失治而发展过来的，人体虚弱，首先就是人体

的能量来源不足了，原因只有一个，胃肠吸收功能不好，这就是一个里虚的问题。就算是里虚的没有出现器质性病变，吃了这么多改善胃肠功能的药物以后，本来有里虚的倾向得以改善，吸收好了，能量就会增加，增加的这些能量恰恰就来支援柴胡，发挥柴胡的作用去推陈致新。

方后注解中有一个去渍再煎，要求把药先煎六升，然后把药渣子去掉，把这六升药再煮，最后煮成三升。现在我们临床中很少按这个要求去做了，但是从临床实际疗效来说呢，对于疗效有什么影响，目前还没有这一类的报道。

最后一个问题，关于小柴胡汤的方后加减。这个条文的后面有一些方剂的加减，《宋本》是同一段内容，《康平本》方后加减是单独的一段，它是附在方后注解之后单独的一个段落。所以很容易让人联想这是后人加的。提出这个观点的，胡希恕是最旗帜鲜明的一个人，虽然不是唯一的一个吧，他是旗帜最鲜明的一个，非常坚决。他说我从来不讲这个，这些都是错的，具体的依据有下面几点：第一，条文中的或然证都是小柴胡汤证范畴里的，只要有小柴胡汤证的主证，下面的或然证哪怕你都有也没有关系，小柴胡汤都能治，没有必要对小柴胡汤进行加减，这是其一；第二呢，经方的加减，并不说经方不能加减，但是经方理论都是以单独的条文来论述的，而不是在方后注后面，另行说明的方式说出来。桂枝加桂汤、桂枝加附子汤，桂枝加黄芪汤，桂枝去芍药汤、桂枝加芍药汤，这一类的方剂很多，甚至有的方剂药物组成完全一样，只是药物之间的剂量的比例不同，也要另做论述，从来不会在方后注后面加一个什么说明。比如小承气汤、厚朴三物汤、厚朴大黄汤这三个方剂，都是厚朴、枳实、大黄三味药，但是他们的比例有所变化，在经方的书里面都是分别论述的；第三个经方的方剂，凡是药味发生变化，甚至药味不变，药味之间的比例发生变化后，它的适应症也都随之发生变化，而且方名也要重新命名。所

以这种通过在方后注一大堆加减的还没有先例，真要那样加减，疗效肯定要大打折扣。小柴胡汤是千古名方，对它进行了加减，经方会越用疗效越差，最后就不用了，实际情况也是这样的情况。

特别提醒大家，小柴胡汤千万要注意一点，绝对不能有里寒证。我给大家说一个失败的医案，好几年了，去朋友家玩，他的一个朋友，她说不太舒服，朋友说这医生就在这儿，我就问她，结果她是小柴胡汤证四证俱全，脉有点沉有点迟，但明显是弦脉，另外她例假有点延期，应该说这两点都是明显的寒证，当时就没有很在意。因为是一边聊天一边问，后来我就给她小柴胡汤，她喝了小柴胡汤，第一天感觉非常好，第二天感觉胃里不舒服。后来她一告诉我，我马上就反应过来了，做了一点吴茱萸的粉，让她再加入到里边。结果呢，她说“我不想喝中药了”。这个病人本来是应该特对证的一个，结果就因为差这么一点，她就对中医没有信心了。

血弱气尽腠理开、邪气因入、与正气相抟、结于胁下、正邪分争、往来寒热、休作有时、嘿嘿不欲饮食、脏腑相违、其病必下^①、邪高病下^②，故使呕也、小柴胡汤主之、（97）

注：

1. “脏腑相违、其病必下”《宋本》作“脏腑相连，其痛必下”。

2 “邪高病下”《宋本》作“邪高痛下”。

胡希恕：这一节非常的好。“血弱气尽”，这就是开始的时候，太阳病，讲麻黄汤时，讲的“阳气重故也”，脉浮紧，那么表证的时候呀，人体以大量的精气往体表来输送，就是津液，那么这种东西哪来的呢，它来自于胃了。那么这个时候没得汗出而解除疾病，而且这个身体呀越来越不能支持了，人这个身体同疾病是永远斗争的，要不然的话人活不了，外界害人身体的病菌病毒有的是呀，这个是个自然

的。这个时候在机体，要防里了，一防里，外边这个体表血弱气尽，不像在表证的时候，咱们都得过感冒，血管非常充涨，那不是血弱气尽，正是体液充实在外，那么在半表半里的时候就不是了，在表血弱气尽，这么个血弱气尽，不是无故地这个人就虚起来了，不是的，他把这个力量都撤到里头去了，在里头抵抗疾病。往里头撤这个体液津液，“腠理开”，皮肤谓之腠，理者肌肉纹理嘛，这个地方都疏松了，人体血气充斥这个地方，它非常致密，津液往里一撤，这个地方就虚了，虚了这个病就往里头来了，“邪气因入”，邪气趁机往里头去了。到哪去了呢？“与正气相搏，结于胁下”，这个正气呀在里头预备另一道防线，集中力量在胁下这个地方，胸腹腔间中间这个地方，就是膜原这个地方，与正气相搏，邪还要往里头进，但是机体不答应它了，在这个地方啊，相拒于这个地方，结于胁下。

“正邪纷争，往来寒热”，这个地方都好得很，那么正邪作战场的地方，就是胁下这个地方，纷争，就是交争，那么正往前进，这个邪退，邪退于表了，就要怕冷，这个太阳病必恶寒啊，那么有的时候正气弱了，邪气进了，邪进于里则恶热，不恶寒，所以这个往来寒热是这么来的，时而退表，时而进里，就是正邪纷争造成的，纷争的时候往来寒热，一阵儿冷，一阵儿热。有的时候不老这么争啊，不争的时候也可以休止，所以“休作有时”，争的时候，一阵儿冷一阵儿热，不争的时候就不见往来寒热。

“默默不欲饮食”，你想在胸腹腔间这个地方，正邪纷争到这么个地步，所以这个人，少阳病是个热病，人昏昏然不愿意吃东西啊，这个热，这个胁下，胸胁这个地方，就是膈这个部位，一定要碍于食欲的。“脏腑相连，其痛必下”，半表半里这个部位呀脏腑相连，一切的脏器呀都在这块儿，上有心肺，再往下就是肝脾，再往下胃肠，肾，子宫，都在这儿呢，脏腑相连啊，虽然结于胁下这个部位，这个热没有不波及到胃肠的。波及到胃肠，胃肠是水谷之海了，激动里边

水，其痛必下，胃肠这个部位一定要疼的。“邪高痛下，”邪在胸胁这个地方，高啊，而疼在肚子，在下边这个地方。上边有热，底下有水气被激动的腹痛，这人要呕了，邪高痛下，故使呕也，主要这个呕还是激动里饮，热激动里饮，它往上撞。“小柴胡汤主之”。这一段就解释上边一切的证候，这个很好啊，那么是不是吃柴胡汤，这个病就整个好呢？也不一定，就看这个病，一般说是能好的，这个病是由表传半表半里，如果这个病是相当的厉害，它还往里头传，但是无论在表也好，在半表半里也好，如果治疗得当，都使着病逐步减轻，但是不一定在这时候好，尤其真正伤寒病，它还要往里传，大概都在白虎汤这个阶段，渴者属阳明。吃完小柴胡汤，那么这一切的证没有了，但是它转成渴了，渴就是胃有热了，这就变成阳明病了，这个阳明病就是所谓白虎汤证了。在临床上这个时候常常就是小柴胡加石膏证最多，也是渴，同时柴胡证不罢，我们就用小柴胡加石膏就行了，这个方子是经常用的，所以这个时候啊的确是一个，最实在，这是通过实践来的东西。

李冠杰：这条在康平本里是降一字格排版的条文。

条文中“脏府相违、其病必下”在宋本里是“脏腑相连、其痛必下”，“邪高病下”在宋本里是“邪高痛下”。这样差别就比较大了，咱们下面通过解读，把这些问题客观地分析一下。

先说“血弱气尽腠理开”。“腠理”是人体部位的名称，原意泛指皮肤肌肉脏腑之纹理，以及皮肤与肌肉交接的地方，是渗泄津液、宣通阳气的门户，有抗御外邪内侵的作用，这是辞海上的解释。“血弱气尽”在这个条文中应该是一个形容词，并不是特指“气尽”。人就凭着一口气，人要没气了就到死亡的时候了，它这就是指人体患了表证以后，由于抵抗力不断下降，以致于最终失去了在体表层面与致病因子抗衡的能力，导致“腠理开”，使疾病进一步发展为更深层次的，或者说更严重的疾病，它就指的是这个意思。

“邪气因入”的本义，这个用不着给古人打掩护，古人的意思就是指外界的致病因子在人体抵抗能力不断降低的情况下，乘虚而入；但是通过现代医学的研究，再看待这个问题的时候，我们应该把它理解成人体防线不断地向后撤退，用中医的话说是人体正气的衰退，相对的看作是病邪往里进，但实际上不是病邪往里进。我们下边以一种疾病做个分析，比如说肝炎，真正健康的人是不会得肝炎的，凡是得这个病的，一般情况下必然有一个浅表性疾病发病的经历，或者是由于失治或者说是由于误治。特殊的除外，比如输血的过程当中，血源的主人就有肝炎，这是很特殊的情况了，不能算作一个正常的病理发展。现在像感冒这一类的疾病，用现代医学的方法来治，基本上都不可以叫做治愈。现代医学说的也很清楚，不能治感冒，只是消除、缓解感冒的症状，但是感冒是治不了的。所以说到一些大医院、正规的医院或者到国外，就因为失治或者误治造成人体免疫力的下调，恰恰这个人体肝脏尤其不好，以致于首先引发肝脏功能降低，从而才发生这种疾病；而不是造成浅表性疾病的比如说感冒病毒，通过肌肤一路长驱直入，进入肝脏造成肝炎。虽然肝炎跟浅表性疾病不能说一点关系没有，但是造成肝炎的直接的因素不是造成浅表性疾病的那些因素，不是那些致病因子。所以说我们今天对“邪气因入”的理解，就应该把它理解成人的正气的退缩。

“与正气相搏，结于胁下”。这实际上是对小柴胡汤证“胸胁苦满”证所作的病理解释。“胸胁苦满”怎么来的？古人认为外界的致病因素由于人体抵抗能力不足，一路深入进去以后，人体在半表半里这一层，在胁下与它作斗争，然后“结于胁下”。

“正邪分争”，本来是对“往来寒热”所作的病理解释，但是这却是本段落里最精彩的地方。它说明中国古人早在数千年以前就对疾病的本质有科学的、深刻的认识。前边我们就说过，凡是疾病都不外乎三个发展方向：一个是自愈，一个是保持原来的状态，一个是进一

步发展成新的、更严重的疾病。那么，这里论述的就是人体在表证阶段没有达到自愈的目的，而且也没有能力保持一直在表证阶段与致病因子抗争下去，所以说人体的抵抗力就弱下来，以后就发展为半表半里证这么一种情况。但是，它不管是哪一类的情况，就算是自愈也好，或者是前面那个层面上与致病因子抗争也好，所有的疾病过程中，都始终贯穿着人体的免疫力与致病因子之间的相互的分争，这一点是永远不变的真理。尽管古人认为是外界的致病因素一路深入进去、由表及里地造成一系列的疾病，现在我们看来不是；但是人体与致病因子之间的抗争，这种性质是永远不会改变的。

我们也能从这里看出另一个挺有意思的事。这类病理方面的解释，顶格条文的作者很少写，他就是摆事实，就讲什么样的证用什么样的方剂来治，因为这些东西是最经典的东西，直到现在也没有人能够否定，而且将来相当一段历史时期内也还否定不了，可以说是绝对的真理。这个对病理的解释，从这一条就看出来解释得非常好，但是随着科学技术水平的提高，研究的深入，你会发现它落后了，方向是对的，具体论述的内容落后了，我们也可以说它不够经典。顶格条文的作者很少论述这一类的东西，他写的全是经典的东西。

“往来寒热”不用说了，前面的条文里已经论述过了。

“休作有时”是这条里的另一个亮点，指的是一种病症在特定的时间有规律地周期性地发作。“休作有时”是半表半里证的又一个典型的症状反映。降一字格条文的作者实际上认为是临床当中总结出来的这么一条，把它放在这里边。作为发病机制来说，它和“往来寒热”基本相同，也是随着人体的节律，疾病的症状会有周期性的变化；但是在临床当中，这种变化有它自己的规律性。我把从临床统计资料中总结出来给大家说说，比较有启发性，“休作有时”的临床当中的规律有这么几项：

第一，疾病发作或者病情变化有固定的时间。比如每月定期发作

的精神方面的疾病，比如嗜睡、惊恐、哭闹等等；比如像月经前发作的经期感冒，每到月经前几天必会感冒；还有每至月经周期吐泻，上吐下泻、然后腹痛；还有每五日一作的定时吐血，这在临床当中也有这一类的情况；或者说每四日一作的伏暑阴疟、疟疾，每三日一作的疟疾，隔日一作的疟疾；还有每日的子午两时发作的神智痴迷、四肢不收；子卯两时加剧的咳嗽，每晨必发的荨麻疹，每日一作的昼日明了、夜则谵语如见鬼状这一类的症状；每日发作的腰疼、发热、还有每日下午必发的往来寒热等等。这些都是带有规律性，当然仅凭这一个症状还不能作为小柴胡汤证的证据，如果再伴随其它小柴胡汤证的话，那么这也就是小柴胡汤所主之证。

第二，发作过程有固定的时限。比如说定时发作手足抽搐，这个眼睛发直，稍候就自己停止了，就跟常人一样；还有每天造成发作的荨麻疹，过了中午以后它自己就消退了，每天都是这么一种情况；那么子午两时发作的那个痴迷，一个小时它就醒如常人了，就是一个小时之后就醒过来了；像子午两时定时发作的这个发热，它持续两个小时，然后就自行消失了；比如说经前一周，有的身体浮肿，那个月经一来它就消失了；还有经前一周发作的感冒，行经三天自行消失，它又自愈了，不用治；像子夜的腰疼，等子时一过就疼痛自消了。这一类的疾病它有固定的发作时限，在这一段时间内发作。

第三是发作常有固定的原因。比如说经期的各种疾病，在没有月经的时候，非月经期它是不发作的。像有的头痛，是每因饮酒、郁怒而诱发。这儿有一个很有意思的事，现在有的酒做广告都说好酒喝不上头，有的人喝了这酒也不头疼，但下一次去喝就出现头疼。如果老是这样子，后来一直在头疼，你再看看是不是有小柴胡汤证。喝了酒以后如果不出现呕吐的，就是胃里不舒服，甚至有点右肋部不舒服，喝小柴胡汤缓解得很快。还有三叉神经痛，多由洗脸、吃饭、情绪激动而触发。慢性胆系病多因情志不遂、饮食不洁而发。这都是有固定

的原因。

第四，发作有定症、定位。比如子时发热了，它这个皮肤灼热，有时候都像烙铁烫醒了一样，每天都这样。还有子时腰疼的，只是夜里边疼。定时发热的，发作的时候就头疼、头晕、乏力、胸闷、时呕，甚至还有有的规律性发热十一年，每月一次，只要是发病就感觉胸胁满闷、腹胀纳差、口中粘腻、咽干吐痰，等这个过去以后就没有什么其它的症状。

第五，休作有定证。就是说发作的过程或结束的时候有固定的表现。比如说往来寒热、休作有时，持续若干时间以后微自汗出，热退身凉，再次发作的时候还以这种形式结束。这也是一种休作有时的一种情况。

仔细地分析一下，我们可以发现，现代医学和经方医学，包括传统医学，对疾病本质的认识都有独到之处，但是它们的侧重面不一样。现代医学它关注的重点是致病因子，而传统医学特别是经方医学关注的是人体自身的因素。正因为基本点的不同，致使医学在治疗理念上也有所不同。现代医学是讲究对抗治疗，是什么样的致病因子造成疾病的，就想办法把这些致病因子消灭掉，在消灭的过程中对人体有多么大的伤害常常就顾及不到了，就没有能力顾及到，如果考虑人体所受的伤害，现代医学很多的治疗办法都不能用了。但是传统医学、特别是经方医学不存在这类的的问题，它是通过增强改善人体的内环境来治疗疾病的。

下边的条文就存在了好多问题。咱们按着康平本的条文来跟大家读一下，后边作个分析。

“脏府相违、其病必下、邪高病下，故使呕也”。像这个条文，我个人的观点是不解释，咱们继承下来的就这些东西，你想把它再完善起来也完善不了，但是这些文字还是以不解释为好，有几个理由：一个是，在康平本和宋本这两个比较完善的版本中，短短的十几个字

就有两个字的差异，而且还是比较关键的字，说明这个条文很难取哪一个为准。特别是像这个，经过推敲以后明显能看出有存在错字，以哪一个为准都有一定的道理。其二，这条前面的条文，后边的条文，从康平本就能看出很多问题。在康平本中明显能看出来好多条文存在明显残缺的情况。这个条文里边的字儿又这么不统一，说明这个条文是否完整也不好说。最后一个因素，这个条文从意思上看，它论述的是“喜呕”这一个症状的病理，但是我们把这两个版本所论述的文字分别进行解读的话，也不能很清晰的反应出它要论述的“呕”是怎么来的，不是很清晰。像这一类的条文反倒不如把它绕开，再看看“喜呕”这个症在小柴胡汤证里是怎么来的？无论从人体的病理上，还是从方剂的药物组成上分析，它都应该是人体本身存在着一定程度的里虚证，里虚就是胃肠功能的低下，它有停水或者吃了东西消化不好，都有可能造成呕。再加上一些精神方面的因素，所以没必要去用那些脏腑相违也好、相连也好解释。大家知道这个事儿就行。

这个条文实际是对小柴胡汤证所作的一个病理解释。它除了休作有时之外，没有特别新的症状出现，多是作的病理解释。但就是这样，我们也应该把它看作这是作者从临床中总结感悟的一些宝贵经验。特别是条文的前半部分，包括了经方医学理论上的一些精华，对经方理论的深入理解还是很有帮助的。

服柴胡汤已渴者、属阳明、以法治之、^{（97）}得病六七日、脉迟浮弱、恶风寒、手足温、医二三下之、不能食、而胁下满痛、面目及身黄、颈项强、小便黄者^①、与柴胡汤、后必下重、^②（98）

注：

1. “小便黄者”《宋本》作“小便难者”。

2. 本条文《康平本》自“脉迟浮”处转行后变为顶格格式，当为笔误。

本渴饮水而呕者、柴胡汤不中与也、食谷者哕、（98）

胡希恕：这一段啊很不好懂，就这本文，这里头意义含着太多。一般的太阳病，五六天，六七天，都是内传少阳的时候。“脉迟浮弱”，迟和弱脉见浮，这就是气血不足于外了，这与上条“血弱气尽”是一个意思。那么这个病要传少阳啊，体表气血就不足了，所以迟和弱都见于浮，脉迟浮弱就是脉浮而迟弱，那么六七天见这个脉，这个病就有内传少阳的一种情况。

“恶风寒”，这是表证还没罢，表证还存在。“手足温”，手足温是与四肢厥冷相对待的，四肢厥冷是里虚有寒，四肢逆冷，厥冷啊，那么这个手足温呢就是内有热，里有热，手足温。但是这个手足温呢在本书里讲的都是“系在太阴”，那么这是什么意思呢？这个阳明病不光手足温，身也热而出汗，甚至于手足也是濈然汗出，这是阳明病。这个手足温当然是里热，那属于阳明病了，他说“系在太阴”，这个热呀不是身热，只是手足温而已，那么说明里面不是光有热，还有湿，就是有水呀。那么这一个病位呀，就是同时里位有两种不同的病，一个就是胃实热，就是咱们说胃家实那一类的，胃实，热结于里，有实，也热，这就阳明病。这个太阴病什么样子呢？太阴病与这个正相反的，也在里位，也就在这个胃肠之里呀，它是一个里头停水，胃虚停水，正与阳明病相反，而且这个水还没有力量收拾，所以吐泻，它是这么一种病，所谓系在太阴，本来是阳明病，可是里头还存在着湿，所以叫系在太阴。在这个书里头啊共有两段“系在太阴”，你们看看这个阳明病里头，187，你们看看这一段，来理解系在太阴这个问题，要不不容易理解，“伤寒，脉浮而缓，手足自温者，是为系在太阴。太阴者身当发黄，若小便自利者不能发黄，至七八日大便硬者为阳明病”，你看这说明什么呢，是在这个里位上开始有热，这个水火这两个东西它不并立的，热盛了，小便数，汗自出，里头马上就是水分尽

去而变成热实。那么这个太阴病呢，是水盛，火就要消失，那么这个在里证，表证传里的时候，那么这个水火是互相进退的，如果阳明病，这个热越重越实，这个水分越丧失，如果阴寒的方面盛，那么饮就重，那么要腹痛下利的，这就叫做太阴病。那么这个太阴病，没有热是没有问题的，有热同时存在的时候是阳明病而有湿，所以他说系在太阴，这个系，咱们拴东西谓之系，与这个太阴病有联系，说明这个阳明病啊，咱们这一段讲的是阳明病了，我们介绍这一段，阳明病要有湿，他说这与太阴病有关系，系在太阴，有湿嘛，这时候水火是互相进退的，如果湿盛，小便也不利，一定要发黄的，这是古人一种看法，关于发黄我一会儿再给讲。

那么小便要是利呢？这个热盛啊，就把津液尽量往外排出，不但小便利，而且汗也出，那大便就要硬了，那就变成阳明病，所以在病初传于里的时候，又有热又有湿，也可以为阳明病，也可以为太阴病，在这个阶段就叫做系在太阴，阳明病没完成，但是里头有停湿，所以他搁个系在太阴，里头有与太阴有关系的问题，他搁个系在太阴，我们方才这一节就是的，这个病六七天啊，由表传入半表半里，而又传于里，传于里呀虽然手足温，这个里有热了，但是它是系在太阴，里头也有湿。

那么这个情况，表证不可下，少阳证不可下，里有湿，更不可下，所以他才说“医二三下之”，这是一个错误啊，这个大夫由于手足温，认为里头是有热了，而二三下之，就是接二连三地给吃泻药，这是错的。那么伤了里，当然就不能吃东西了，伤了胃气了，那么同时这个少阳病也很明显，这个伤了胃呀，胃气一虚，邪热，客气都往胃这块儿来，当然是半表半里的热，表热都往胃这块儿聚，那么湿呢，这个水气也往这块儿聚，所以“胁下满痛”，胁下，连心下这个部分都有了，胸胁满，胁下满，这就是胸胁苦满的少阳病的那个证候，由于邪热、客气都往这块儿聚，所以他也疼。

“面目及身黄”，那么又有热又有湿，非发黄不可。那么古人认为这个黄啊，这是由湿热，郁热在里造成的，由于这个系在太阴说身必发黄，古人这么个看法，这是个错误，古人认为脾属土，土色黄，那么这个它是个错误，现在黄疸都是胆道受了障碍，一般这样的多了，这是很清楚个事情，不在乎脾土色黄，这是胆汁的色。可是虽然这么说，古人这种治疗所掌握的规律是对的，你象咱们用这个茵陈蒿汤，或者是茵陈五苓这类的药啊，去湿去热，那么这个治疗呢，永远也是对的，古人只是掌握这种规律，那么这个脾的关系是没有的，古人没法那么认识，不知道有这个物理的障碍而使着人发黄，他不懂得这个，所以古人一看到这个黄啊都是属太阴，因为太阴是运湿呀，太阴有病不能运湿了，再要有热，他一定发黄的。古人这么个看法，这个规律是对的，古人说郁热在里，那么治疗的方剂这都是非常正确的，现在我们这么用还是有效嘛，所以我们研究古人的东西呀，我们要掌握这种规律方法，那么至于这个古人这种说法，咱们现在这个辨证，尤其拿脏腑辨证，很成问题的，因为他搞不清，古人限于科学水平啊可要知道，你比如这个书吧，也就是一千好几百年，两千年了，那个时候科学还是没有这么样的进步发展，没法来认识，疾病的这个问题，它都关于生理病理呀，这是一种基础科学的问题，那个时候没有，没有怎么办呢？人他也想解释，他就是让脑子想，或者就是拿现象当本质，这个土色是黄的，这个黄就是，咱们根据五行来说，脾属土，土色黄，就这么样来看。尽管看的错误，那么这个规律是一点不错，尤其发病的这种情况，比方底下他说“小便难”，那么在这个太阴病，我们方才讲那节也是，如果小便利，这个湿热能够外越，他不发黄，我们现在临床上也是这样的，大概的黄疸病啊都是小便不好，那么我们治疗呢也是去利小便，去热，湿热，那么这一类的治疗的手段，多咱都是对的，这是规律，古人对这个规律的这种认识法可是不对的。“与柴胡汤，后必下重”，这种内里头有湿热，那么柴胡这个药啊有点疏泄

作用，同时它去热，解热剂嘛，你再撤其热，你再加以疏泄，这个湿热下注，“胁下满痛”，“颈项强”，这个颈项强，颈就是两侧，项就是后头，人这个脖子两侧谓之颈，两侧颈属少阳，项，后面呢属太阳，由于这个病，太阳也没罢，少阳病也发生，所以他颈项强，根据这个胁下满痛，颈项强，可以用小柴胡汤，这个证候啊颇象小柴胡汤证。

但是这个情形之下，什么情形？“本渴，饮水而呕者”，这个是水逆证候，本渴，可是一喝水就要吐，这就是我们上面讲的五苓散证，水逆。这个水逆里头这个水相当多呀，而且这个水冲逆于上，那么这个时候使柴胡是不行的，非用这个五苓散治这个水逆才行的，他这个就是茵陈五苓（散）来利水去黄，这就对了，这个柴胡汤不能用，要是用的话，不但后必下重，而且食谷则哕，这个水停得非常地多呀，水往上冲逆，你咽东西咽不下去，要哕逆的。这是个倒装句，他说与柴胡汤后必下重，尽指着这个本渴欲饮而呕者，上面说这个不能食，里头就有个呕啊，而且饮水也呕，上面没说这个证候，底下说清楚了。根据上面这个证候，他就柴胡汤了，也治黄啊，在这个《金匱要略》里头，黄疸篇就有，他说诸黄腹痛而呕者，宜柴胡汤。那么这里也呕，尤其这个证候正是柴胡证，胁下满微痛，颈项强，这可以用小柴胡汤。但是他是注重在底下这一句话，是个倒装句，他说是本渴饮水而呕者，这么个呕，水逆，本来他渴，想喝水，一喝水就吐，这不就是水逆证嘛。要有水逆这类的黄疸，虽然有柴胡证，不能用柴胡汤。假设要用的话，就有后重和食谷则哕，因为这个柴胡汤啊不能治水逆，同时有疏泄胸胁的作用，去心腹间结气、积聚，有疏泄的这么一种作用，同时一撤热，水势更泛了，所以食谷要哕逆的。

这段书包含的意思非常地广，那么我们离开这个本文，这倒好理解这一段，根据上边五六日，无论伤寒或中风，全要传入少阳，这么一个时期，那么六七天更是了，五六天、六七天嘛。而且这个脉呢，

已经有内传少阳的一种征象，脉迟浮弱，不但传少阳，而且表证也没罢，还恶风寒，虽有里热，手足温，手足自温，但是里热不重的，还系在太阴，只手足温而已嘛，里头还是有湿。那么这一系列的情形，少阳病不可吐下，后头有的，我们讲到少阳篇就知道了，表不解，更不能用下药，那么里头有停湿，不是有实热，也不能用下药，所以以上的这种情况，一概不能用下药，而这个大夫反接二连三下之，这都错误，所以少阳证就该明显了，胁下满且痛，因为表证还有嘛，表证有，用药不对头，一定导致气上冲的，表也不能解，所以不但颈强，项也强，头项强痛那个项，所以太阳病也没罢。那么由于气冲，水往上不往下，所以小便不利。那么既有热，小便又不利，非发黄不可，所以面目及身黄，本文的意思就这个。可是这个时候呢，这个水往上逆得厉害，同时人渴，但是饮水则吐，这是水逆证，这种发黄，应该用茵陈五苓就对了，就是五苓散加茵陈，一方面治水逆，一方面去黄，而柴胡汤是不能用的，不能与。要是与的话，下利后重，而且食谷则哕。所以这个水逆证，虽有柴胡汤证，不能用。这还是论述小柴胡汤的应用。这段相当地大，内容相当地复杂，那么古人啊对表、里、半表半里，古人通过对疾病的观察呀，发现疾病万变，在病位的反应啊，不出三个，一个是表，一个是里，一个是半表半里。可是每一个病位的反应，都有两种证候，或阴或阳，阳有热实，阴有虚寒，所以表有阴阳，里有阴阳，半表半里有阴阳，咱们开始讲太阳病，病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也，所以在一个表位上，也有两种，一个太阳，一个少阴。里证，根据我方才讲这个，在里位上也有两种，一种阳明，一种太阴，所以在阳明病里头常有系在太阴的关系。所以这一段啊，不这么详细说不好理解。

李冠杰：“服柴胡汤已渴者，属阳明，以法治之。得病六七日，脉迟浮弱，恶风寒，手足温，医二三下之，不能食，而胁下满痛，面目及身黄，颈项强，小便黄者，与柴胡汤。后必下重”。这个条文我

们不能一句话就断定是顶格条文、还是降一字格的。一般地说这个条文肯定不是降两字格的条文。

但是这个条文既有降一字格排版的内容，又有顶格的内容，而且在排版格式与段落划分上都存在着明显的问题。

首先条文的头一句：“服柴胡汤已渴者，属阳明，以法治之”。在《宋本》上是上一段的内容，是第 97 条的内容。但是在《康平本》里边呢，它和第 98 条是同一段内容，所以我们把它挪到这儿来跟它一块学习。但是论述的内容，严格地说也不是一个相同的主题，这是一个问题。

另外一个问题，第 98 条里边在排版格式上出现了一个特殊情况，“得病六七日、脉迟浮”在《康平本》里边就到了这一行的最末了，前边的跟我们前边读的那一小段是相连接的，“脉迟浮弱”到这个“弱”的时候另起一行。但是这个另起的一行，它由前边的降一字格排版的内容，一下就转成了顶格排版的。这应该是抄的人抄错了，从“得病六七日，脉迟浮弱”，这个地方本来就为顶格的？还是这一段都是降一字格的条文，这个地方另起一行的时候，它是开错了头了？到底是什么呢？现在就不敢说了，反正这个地方明显的是错误。因为它是同一句话，中间就连标点都不应该点在这个地方。同一句话不可能出在两个作者之手，所以这个地方就是个明显的错误。

还有一个地方，条文里边的“小便黄者”，在《宋本》里边是“小便难者”。“难”跟“黄”两个字如果放在《宋本》里边，它就不是一个症状，虽然一字之差，但意思却大相径庭，对条文的理解就产生很大影响。现在还没有一个依据去肯定哪一个版本是正确的，所以这个条文存在着很多的疑问。如果单独去学习《宋本》的话，这些信息是完全看不出来的，完全没有。

下边我们就开始解读，从段落划分上，我们还是按照《康平本》来学习，其中有些问题我们都应该给它找一个着落，我想这涉及到整

个段落学习方法的问题。

“服柴胡汤已渴者，属阳明，以法治之”。从这个论述的内容而言，这一段文字就应该是一个单独的段落。属于 97 条也不太合理，属于 98 条也不是衔接的特别得好，咱们就把它当做一个自然段来学习。

这个条文的大致是说服了小柴胡汤以后，小柴胡汤证基本上消失了，但是他还遗留口渴之类的里热的症状的话，它就不属于小柴胡汤的治疗的范畴了。因为前边已经服过小柴胡汤了，小柴胡汤里边也出现口渴，但是他是已经喝过小柴胡汤了，口渴没有消失，说明有里热。这应该按照阳明病的方法来治，是白虎汤证就给白虎汤，白虎加人参汤证就给白虎加人参汤。它这儿论述的，就是半表半里虚热证和里热证同病的这么一种情况，虽然说里热证不是特别的重，但是存在。按照经方的治疗原则，应该是先治少阳病，然后再治阳明病，同时治疗也不是不可以的。在辨证的过程中因为阳明病比较轻微，随着少阳病的痊愈，也许阳明病会随着少阳病的消失它也会自愈；但是这儿要说明另一种情况，如果阳明病比较重，或者阳明病当时在辨证的过程中症状并不明显，很可能就是一个口渴，但是这个人的整体疾病非常严重，在这个过程中很可能会出现少阳病消失了，但是阳明病的症状又凸显出来了，就按照阳明病来治了。这是这一小节大致的一个意思。

下边的才是《宋本》的第 98 条。原文我们刚才已经读过了，我们就不读了。

这一条在段落划分和关键字上，《康》、《宋》两个版本存在着明显的差异，从《康平本》上也能明显地看出来，原书实际上这个地方就存在着好多是不太完整。从这个条文的内容上看，它论述的是小柴胡汤的禁忌症，但是我们要围绕着这个主题去看这个条文的话，它论述得并不是很清晰。是不是这个条文还另有其他的意思？比如在最后还有其他的文字丢掉了？现在就很难说了。

咱们下边看看条文：

“得病六七日”，并没有说什么病，但是这六七日明显就是说病程较长，这里暗含着经方书里边的一贯的风格，它暗含着疾病存在着或加重，或变为其他类型的疾病的这种因素。

“脉迟浮弱”，脉动的次数偏少，“浮取缓弱”这么一种脉象，它候的是气血不足于外这么一种证候。

“恶风寒”，很明显表证仍在，反过来印证前文当中的“得病六七日”，得的什么病，最起码是有表证存在，不一定就是一个单纯的表证，但是绝对有表证的因素。

“手足温”，这个症状与手足厥逆是相对的，实际就是手足偏于热，自己感觉或他人触摸比正常温度偏高。手足厥逆常常是里寒，“手足温”一般就是候里有热。

这么一个症状，“医二三下之”，这肯定就是误治了。因为上边所有的论述都构不成用下法的证据。要把它看做是表证，表证用下法肯定是误治了；如果是里实证，但是你绝对看不到他论述里实证的证据，没有里实，仅仅是有里热，下法也不对，假设是有里热的话，应该是清热。

误治以后就出现了下边诸多的症状，“不能食而胁下满痛”，这个都是少阳病比较典型的症状反应。我们可以把它看做是“不欲饮食”和“胸胁苦满”的另一种表述形式。

“面目及身黄”，实际这就是黄疸。这里我们应该把它理解成误下以后，加重了里热，同时又出现了停饮，湿热在里引发了黄疸。但是黄疸病出现在小柴胡汤证中，小柴胡汤也能治黄疸，只要表现为小柴胡汤证就可以。所以说，黄疸也构不成小柴胡汤的禁忌证。

“颈项强”，“颈”指的就是咱们这个颈部的两侧，“项”是指的后边，在这“颈项”我们就可以把它理解成是少阳与太阳合病的这么一种证候。关于这个“颈”，有研究经方的人有这样的说法，怀疑

有小柴胡汤证，但是又找不到确切的证据，而且又没有其他的明显的症状，说明他有其他类型疾病。这时候你想证实下是不是小柴胡汤证，可以用手捏他脖子两侧的肌肉，如果有少阳病的人，这个地方非常敏感，而且说得非常具体，第二次捏的时候，他特别敏感，手往那一放他就有点想躲的感觉，不想让你去捏他，非常敏感，从这就能看出这个地方。但是我们不要把它理解成这就是胆经循行的路线，少阳经，大家不要这么去理解。

为什么恰恰就在这一个证候上这么吻合呢？包括胸胁也是这一个地方。

实际上经方是以症状来界定疾病的，经络是以人体的循行部位来界定的。但是它们在界定的思路，在道理上有相通的地方。比如像经方里的太阳病就是指的最浅表的疾病。而经络的太阳经，也是指的人在人体循行部位阳部分布最广，在体表上占的面积最多的经络。如果一个人面冲地趴着，太阳经和其他的经络比较一下就会发现，太阳经最靠外，少阳经次之，等于说也就是那么一个半表半里的位置，阳明经就到了里边了。

经方在界定疾病，划分这些症状的时候，纳入了跟命名经络相同的一种分类方法，而且疾病反应症状也好，经络也好都是产生在人身上，都在人身上表现出来，所以有时会有比较接近的。但是千万不要把它想象成这就是经络，这就是某某脏腑，或者说人体的某一层，一旦那么去想，对你的临床辨证，对正确的理解经方理论，就会有所影响。经方里的证指的就是症状，通过症状去划分。后边还会逐渐地跟大家讲清，这是一个不太容易拐的一个弯。

“小便黄”，在《宋本》里边是“小便难”，虽然这一字之差，小便黄一般是里有热的症状，小便难是停饮的症状。我们现在还真确定不了这两个放在这个条文里边，虽然代表的意思不一样，但是都有可能，所以没法肯定哪一个对的，哪一个错的。

“与柴胡汤，后必下重”，也就是说上边论述的这些情况，如果施以小柴胡汤治疗，就会可能出现里急后重这样的不良后果。

我们整体地回顾下这第 98 条，实际上他说的应该是一个三阳合病，同时又有停饮，并且还引发了黄疸这种病，大概就是这么一种病理。但是单纯从三阳合病这个角度看，用小柴胡汤应该是对的，有热也没有问题，三阳合病里边已经包括里热了，剩下一个问题就是“湿”。这个条文论述的是有湿的情况下，或者说有湿热的情况下，单独用小柴胡汤治疗不合适，不宜用小柴胡汤治疗。如果我们遇到这一类的情況，大家看看这个论述，恐怕我觉得应该是一个小柴胡汤合上茵陈五苓散这一类的方证。

我们再往下看，第 98 条后边还有一部分，在《宋本》里边，把它纳入到第 98 条里边，但是在《康平本》里边，是个单独的段落。

内容是这样的：“本渴饮水而呕者，柴胡汤不中与也，食谷者哕”。这一条因为在《康平本》里边是一个单独的段落，咱们就把它当做第 98 条附属的又一部分。要是按照《宋本》的划分，这一条就又乱了，因为在《宋本》里边归到其他的条文里边了，在《康平本》里边是自己一段。

“本渴饮水而呕者”，这个地方指的就是五苓散证，所谓的水逆证。

“柴胡汤不中与也，食谷者哕”。对于里有停饮的人，不宜以少阳病来施治，否则的话，会发生吃东西以后，哕逆的情况。有里饮证，特别是比较重的里饮，到水逆证的程度了，就不宜用柴胡汤来治疗，这也算是柴胡汤的一个禁忌。

因为这个条文比较乱，而且论述的不是特别得清晰，咱们就不再做小结了。

伤寒四五日、身热恶风、颈项强、胁下满、手足温而渴者、小柴胡汤主之、（99）

胡希恕：你看看这一段同上面那一段证候差不多，那么伤寒也好，中风也好，到四五天，五六天，六七天这个时候，一般都是多传少阳病，在临床上也是，这个感冒一过去，头两天，到三四天，四五天，它就传少阳。“身热恶风”，这个身热不光传少阳，里头也有热，就是身热，都是发热了。恶风，表还没罢。“颈项强”，你看他也搁个颈项强，两侧谓之颈，后面谓之项，这就是既有太阳病，也有少阳病，所以颈项俱强。“胁下满”，这就是胸胁苦满了，这是有少阳柴胡证了。“手足温而渴”，手足温又渴，里有热，但是也不到整个阳明病的情况。在这个情形，所以是三阳并病的样子，就是由表证传入半表半里，又系于里了，里头也有热了。

这个三阳并病啊，也应该取少阳治之，所以他用小柴胡汤，这是个定法。怎么讲呢？表证是可汗，少阳病不能发汗。里实证，里有热可下，少阳病不能下，我们讲到少阳篇里都有，所以这个三阳并病，既有少阳病存在，又不能汗，又不能下，只能够取少阳治之，这是定法，在临床上也是必要的。我们在临床上常遇到这种情形，表证过去了，表证还存在，也还怕冷，怕风，可是呢少阳病相当地明显，尤其胸胁苦满，这是少阳病的部位，那么他又渴，手足也热，或者身热，这里头也热了，里盛也有了，那么这时候我们要用啊，就用小柴胡加石膏最好了，这一段也是的，不过他没说，就说个小柴胡汤主之，我们在临床上呢一般都用小柴胡加石膏，这个可以说是百发百中，这个在临床上常遇到这种情况。

那么这个同上面不同的在哪，你们看一看，就是一个渴饮水而呕，这个没有，他渴，不是饮水而呕，不是水逆，所以这个可以用小柴胡汤。那么这个他没说发黄，就即使发黄，有小便不利，也可以用小柴胡汤，没问题的。那么就是上面那个只用小柴胡汤不行，我们通过实

践，用小柴胡汤合用茵陈五苓，我认为是最好了，这是上面那个，“柴胡不中与也”那个，那个用小柴胡汤与茵陈五苓合用最好了，因为什么？因为柴胡证还很清楚嘛，但是只用小柴胡可不行。那么这一段呢，就是小柴胡汤证，所以就用小柴胡汤就行了。所以这个他就怕你上面不明白，他在这里又附这么一节，99条就这样了。那个“柴胡不中与也”，不是根据上边的柴胡证而不得与柴胡汤，是因为有个“渴饮水而呕”，这是水逆证，小柴胡汤不能够用的，指着这一条来讲是不行的。在这里，这一节就证明前一条为什么不能用小柴胡汤的意思。

李冠杰：这是一个顶格的条文。

下边我们解读一下：

“伤寒四五日”，指患表证已经多日了，经方里边把这个日子用来暗指有发展成少阳病的可能。

“身热恶风”，这是典型的太阳病的反应症状。

“颈项强”，可以把颈项强视为是太阳少阳合病。

“胁下满”，是小柴胡汤证的典型的症状反应，应该看做是胸胁苦满的另一种表述形式。

“手足温而渴”，是典型的阳明病的症状反应。

这儿论述的是一个比较典型的三阳合病的情况。但是在治疗上却单独用了小柴胡汤来治疗。这是简单地看，要是稍微往深处一想呢，就会想到三阳合病也要用小柴胡汤来治。

但实际上，这个比较短小很规则的条文，里边却隐含了比较深的道理，咱们一点点地分析下：

实际上，这里就涉及到了治疗原则的问题。

同时也涉及到了不同的疾病，所占比例不同的解决的办法。前边多次讲到了太阳少阳合病，太阳阳明合病。那么合病里边有没有各占分量大小的问题呀？太阳合病里边有啊，桂枝二麻黄一汤，那就是桂枝汤的症状要大于麻黄汤的症状。那么，在不同类型的疾病同时发生

了，是不是也存在比重的问题呢？下边仔细的分析分析。

先看治疗原则这一方面。按照经方的治疗原则，太阳病需要发汗解表；阳明病的治疗应该用清热或者说是泻下的方法来治疗；但是少阳病既不能汗，也不能下。所以说，三阳合病里边或者说阳性病里边，一旦有少阳病存在，就只能从少阳病施治，其他的都得后考虑。所以，后世把小柴胡汤称作是“和法”。

那么从症状上，我们分析一下：这儿就涉及到了不同类型疾病之间的比例问题。太阳病的症状，只是“身热恶风”和“颈项强”。但是“身热恶风”当中的“身热”，是太阳和少阳都有的症状。少阳病常常会出现发热的问题，甚至有时候是高热。那么“身热”在这儿，就不能认为是太阳病独有的症状，应该是和少阳病同有的。那么“颈项强”呢，“颈”就偏于少阳；项偏于太阳。这两个症状虽然涉及到了太阳病，但是，真正属于太阳病的症状，相比之下就轻微了。因为，将近百分之五十的症状是跟少阳病共有的症状。只剩下“项强”和“恶风”这两个症状，是真正属于太阳病的症状。

“手足温而渴者”，这个“渴”也是阳明病和少阳病共有的症状反应，小柴胡汤证里边不是有个“或渴”嘛。所以，单纯的里热反应仅仅是“手足温”这一项。而且呢，“手足温”在阳明病里边，候的应该是轻症。如果是重症的话，比如“蒸蒸发热”或“大汗出”这一类的，那都是比较重的。仅仅是“手足温”，这也是比较轻。所以说这个地方，阳明病的比重也不大。

虽然少阳病的症状只有“胁下满”一个症状，但是，它却是少阳病里边典型的症状反应，四大主证之一。而且呢，所论述的太阳病和阳明病里边，都有少阳病的证候存在。

我们这样一分析，这一条论述的：是一种以少阳病为主要矛盾，同时兼有太阳病和阳明病的这么一种情况。虽然说是三阳合病，但是，少阳病所占的比重要大于太阳病和阳明病。那么，在这种情况下，只

要少阳病治愈了，人体的抵抗力就会增强，人体的抵抗力增强了，其他的两个本来不算很重的疾病就会随之而愈。就跟我们学五苓散的时候，你把水去掉了，表证也就去了。虽然说五苓散有一味桂枝，但是它的解表功能就非常弱了。真正表证好的原因，是因为里水去掉了，里边理顺了，功能恢复了，人的抵抗力强了，在表证阶段抗病的能力强了，疾病就可自愈。所以这儿呢，只用小柴胡汤施治就可以了。

下边做个小结：患伤寒病四五日的时间，症状表现为身热恶风，颈项强，胁下满，手足温而渴的，为小柴胡汤主治之证。

通过学习这一条，提醒大家在临床辨证当中，辨不同类型疾病错杂而且所占的比重大小，也是一项很重要的基本功。同时相同类型疾病之间，有时候不同疾病性质之间，也会存在错杂的情况。比如：虚实错杂，寒热错杂。半夏泻心汤就是典型的寒热错杂。这个呢，都是我们在临床当中，需要慢慢地去掌握的基本功。我们最终要达到什么目的呢？就是李翰卿老中医说的那句话：“用药最后要达到丝丝入扣”。

伤寒阳脉涩阴脉弦、法当腹中急痛。□□①先与小建中汤、不差者、小柴胡汤主之、（100）

注：《宋本》无此二个缺字符号。

小建中汤方

桂枝三两去皮 甘草二两炙 大枣十二枚擘 芍药六两 生姜三两切 胶饴一升

右六味、以水七升、煮取三升、去滓内饴、更上微火消解、温服一升、日三服、

呕家不可用建中汤、以甜故也、

胡希恕：“阳脉涩”就是脉浮涩，谓之阳脉涩。阳就指着外面，浮取脉涩，但是按着呢脉弦，上下弦直有力，那么这类的脉呀就是里寒，外血不足，就是中虚有寒，那么营卫不足于外了，所以阳脉涩阴脉弦，那么这个是小建中汤的脉，中气虚嘛，虚者生寒嘛。那么中气一虚，不能消化水谷，所以外面营卫气虚，阳脉涩，涩是血不足啊，津液不足脉也涩，这是一个说法。那么根据这个，“依法当腹痛”，但是这个弦脉呀也为少阳脉，阳脉涩，真正少阳病，尤其到柴胡证这个阶段，气血也不足于外，血弱气尽嘛，咱们头前也讲了，阳脉也是涩，那么按着脉弦，这是少阳病，那么小柴胡汤证呢也是腹痛，所以这类的脉，“法当腹中急痛”，这种脉依法应该腹中发急痛，这个急痛啊也可以说是拘挛痛，拘急痛，现于小建中汤。那么根据这个脉呢，小建中汤脉是这样的，里有寒，弦主寒，也主疼，拘急痛啊脉也弦。根据里虚寒而营卫不足于外，这是小建中汤证，那么这个脉同时都存在。这个柴胡证腹痛也有这种脉，为什么先与小建中汤？这个我们讲很多了，里要是需要温补的，必须先救里，这个是先里后外，这个少阳在半表半里，里之外呀。这也是定法，所以他先用小建中汤。那么根据这个脉，既有小建中汤证，也有柴胡证，所以他先与小建中汤，也是先救里而后外的意思。“不差者”，不差者不是一点没好，总是这个疼没完全好。没完全好，那就是柴胡证的问题了，所以“小柴胡汤主之”。

这一段在临床上也容易遭遇的，因为这个脉，小建中汤也是这个脉，柴胡证的脉也现这种脉。那么根据这种脉，这个病人的肚子疼，这种脉应该肚子疼，所以“依法腹中当急痛”。那么既可能是建中证，也可能是柴胡证，得先怎么治呀？得先温里。这个里需温需补都得从里治，这个里需攻需下，那就先从外治，这是定法，我们头前讲很多了，这一段也是这样。那么也就是说阳脉涩阴脉弦，根本这个脉呀既有建中证，也有柴胡证，在这个治疗的结果上来看，所以先与小建

中汤，这也是一定的治疗的步骤，要是没完全好，再用小柴胡汤主之，绝对能好的。

小建中汤这个药啊，就是桂枝汤增量芍药，原来芍药是3两，现在是6两，这个芍药就治拘挛痛，腹发拘挛痛。但是芍药微寒，里虚有寒，光用芍药是不行的，得搁饴糖，大量饴糖，他搁1升啊，这个1升啊拿现在说是1碗，就那个茶杯呀1杯，我们平时开药都搁1两半，这个饴糖甜，是甜都能补痛，饴糖配合芍药治腹急痛相当有力的，为什么叫小建中汤呢，在桂枝汤的基础上，桂枝汤是解表的，那么这个方子就是治桂枝汤证，在桂枝汤的基础上，中虚有寒而腹急痛，它是这么一个用法。那么这个方子也解表，有很多的里虚而表不解，腹痛，这个方子也非常好使。咱们说甘温除热呀，这个方子也是甘温除热一个代表方剂了。肠结核腹痛发烧，我用这个方子治过，挺好使的。所以小建中汤还解表呢，不是整个建中，所以叫做小，不像大建中，大建中整个是温里补里。

李冠杰：“伤寒阳脉涩阴脉弦”，这儿有个旁注：“法当腹中急痛”，这儿在《康平本》还有两个缺字符，下边是“先与小建中汤，不差者，小柴胡汤主之”。这个条文在《康平本》里边是顶格排版的条文。

《康平本》这两个缺字符，在《宋本》里边没有。

下边解读一下：

“伤寒阳脉涩阴脉弦”，“伤寒”在这儿我们应该把它理解成：病人有明显的表证的症状反应。“阳脉涩”，就是浮取的时候，现涩象，呈涩脉。这样的脉为津血不足于表的应证。“阴脉弦”，沉取现弦脉。在经方里边，弦脉候疼痛、候里寒、候停饮，不是单独的一个证候。在这个条文里边，应该是里虚寒兼有腹痛的这么一种应证。

“法当腹中急痛”，是旁注的文字。《康平本》恰恰在这个地方，正文缺少了两个字。这一段注解文字，应该是为这两个缺字做的注解。

按照脉象和治疗方剂来看，小建中汤证应该有腹痛这样的症状。所以我个人认为，缺的这两个字，应该是“腹痛”两个字，比较贴切。这也看出旁注的作者还是比较严谨的。就是没有填上这两个缺字，只做了一个旁注。

“先与小建中汤，不差者，小柴胡汤主之”。仅从字面上看，明显有以小建中汤试探的意思。所以历史上的伤寒学者们，有的对这个地方颇有微词。认为像张仲景这样的临床高手，不应该有以方试病的这样的做法，不应该有这样的道理。实际上这个地方是有道理的。咱们下边分析：

条文里之所以这么说，就是示人以施治和辨证的方法。让你从中学习辨证和施治的方法。如果说要深刻理解，就必须参照治疗方剂，才能全面的理解。

小建中汤治疗的是一种里有虚寒、外有表证的病理状态。同时还应该有血虚的状态存在。与这一条条文中所列举的脉证呢，是相吻合的。

这个“阳脉涩阴脉弦”，在小柴胡汤证里边，也可能出现。而且，腹痛这个症状，也是小建中汤和小柴胡汤共有的症状反应。但是不管是表证也好，还是半表半里证也好，一旦与里虚寒证同时存在的时候，其他的都不重要了，应该先温其里。而小建中汤恰恰就是以温里为主的一个方剂。所以就应该先用小建中汤来治疗里虚寒证。服了小建中汤以后，里虚寒证已经消失了，表证也得解了。这个时候还有一点腹痛的症状的话，它就不是小建中汤所能治疗的了，就是小柴胡汤证了。实际上就想说这么一个意思。

那么，小建中汤证的病理：里虚寒证合并表虚证和血虚证。

下边做个小结：患伤寒证，症状表现为阳脉涩阴脉弦，而且腹中急痛的，先与小建中汤治疗，如果未能痊愈，则为小柴胡汤主治之证。

下面我们来看看小建中汤的方剂。这个方剂由六味中药组成，实际是桂枝加芍药汤，又加了饴糖。饴糖用量比较大，用了一升，大概

是 200 克左右，比其他的药都要大得多。饴糖是一味温性的补里虚的药物，对于因里虚寒证所造成的胃肠功能低下而引起的诸多疾病都有特效。

实际上这个方剂，可以看做桂枝加芍药汤证伴有里虚寒证这么一种情况。

下面是这个方剂的临床统计资料。

症状：纳呆、疲乏无力、消瘦、面白无华、胃脘痛、喜暖喜按，这是比较典型的症状。

脉象：弦脉、细脉、沉脉、弱脉。

舌质：以淡红舌为主。

舌苔：以薄白为主。

关于小建中汤的现代应用：十二指肠溃疡、胃溃疡、胃脘痛、腹痛、消化不良、胃弛缓、胃下垂、胃痉挛、急性胃炎、慢性胃炎、慢性肠炎、胃酸过多或过少症、习惯性便秘、慢性肝炎、贫血、白血症、脊髓空洞症、白塞氏综合征、慢性胰腺炎、溶血性黄疸、红斑性狼疮、心神经性官能症、神经衰弱、神经抑郁症、心律不齐、缺铁性贫血、再生障碍性贫血、血小板减少性紫癜、过敏性紫癜、功能性发热、肠系膜淋巴结核、水疱性结膜炎、眼底出血、闭经、痛经、呃逆、产后腹中痛或少腹拘急痛引腰背（这个应该是中医的症状的名称，让人统计在这了）、不能饮食、阴血内虚（这儿呢是从书上抄的吧，虽然不是用的西医的名字，但是可以帮助我们理解它所治疗的病谱，就是西医名所不包括的方面）、小儿反复发作性腹痛、松果体瘤。这是有小建中汤治愈机会的现代病。

下面还有一段文字需要我跟大家说一下，就是“呕家不可用建中汤，以甜故也”。这个条文在《康平本》里边是降两字格排版的条文。可是在《宋本》里边呢，是小建中汤方后注解的一个附注内容。而且在《康平本》里边呢，是附在方后注解后的一个独立的段落。应该是

本文的作者临床所得。咱们就仅作参考吧。

伤寒中风、有柴胡证，但见一证便是，不必悉具、（101）

凡柴胡汤病证而下之、若柴胡证不罢者、复与柴胡汤、
必蒸蒸而振、却复发热汗出而解、（101）

胡希恕：伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。这是一段，下面应该还另有一节。凡柴胡汤证而下之，若柴胡汤证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。这是两段。无论伤寒或中风，如果发现柴胡证，但见其中主证中一证，就可以用柴胡汤。这个主证是什么呢？往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，这是柴胡四证。那么不是说柴胡证这四个都具备，他意思是这个，其间有一个主证，就有机会用小柴胡汤。他这个话我们要活看，这一证也需要结合其他的脉证而来观察，后头有例子。并不是说非得有往来寒热、胸胁苦满、默默不欲饮食、心烦喜呕具备才用柴胡汤，不是的，不要这么样子看，而这四个主要症状其中有一个，再观察脉证可以用小柴胡汤的一样可以用，不必都具。这是一节。

“凡柴胡汤证而下之”，这个柴胡汤证不应该下，如果误下，那么这个柴胡汤证幸而未因下而罢，柴胡汤证还存在，那么这个时候还可以用柴胡汤治。“复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却发热汗出而解”，这句话呀给后世造成很大的问题，这就说柴胡汤是发汗，它哪发汗呀，这个“蒸蒸而振”，蒸蒸是热象，那么服完柴胡汤之后，先蒸蒸然人感觉发烧，蒸蒸然，继而打战战，“而振”，振就是振战，打寒战，然后发热汗出，病就好了。这不是出汗嘛？其实这是冥眩状态，哪有这么出汗的。这是什么道理呢？一个病，邪盛正虚的时候，我们吃药要中病啊，常常发生冥眩状态。冥眩状态，古人有这么一句话，咱们头前也讲了，就是“若药不冥眩，厥疾不疗”，这是《尚书》上一句

话。所以服了药之后，有一种特殊的反应，不正常的反应，很吓人的，你看这个也很吓人的，折腾人啊，蒸蒸而振，这个蒸蒸不是个好发热的样子，这个人感觉里头啊其热蒸蒸的，然后打寒战，完了出一身大汗。可是这样，这叫冥眩，这就是药中病发冥眩。不是说服柴胡汤都这样的，下之后，这个要注意的。那么这个病误给下了，挫伤人的正气，体力虚衰了，可这个病还存在，这个时候与柴胡汤常发生这种情形，所以我们在临床上要注意这一点，假设这个病人原起就是柴胡汤证，已经吃了泻药了，柴胡汤证还存在，给柴胡汤常发生冥眩，这时候你得告诉病人，不告诉他，非上急诊不可。

蒸蒸而振，出一身大汗，他就吓坏了。你告诉他这是冥眩，有这个情形这个病马上就好。这个不是柴胡汤能发汗，柴胡汤不能发汗的，这是冥眩状态，冥眩状态常有这种情形。这个柴胡汤啊有这么一个问题，常有这种反应。人要不虚，没有这种反应，或者久不治，再者就是给吃错药了，伤人体力了，那么这个时候柴胡汤证还存在，当然得与柴胡汤，可这个时候就常常地发生冥眩状态。这个要告诉病人的，所以这个时候要给他吃这个药，说你加小心，吃这药有这种反应，可有这种反应非常地好，这个病马上就好了。也有时候不发生这种反应，你身体不那么虚，就不发生这种反应。发生反应不要害怕。它不是发汗药，这个一般注家呀就根据这句话，说柴胡啊升散，把柴胡也弄个发汗药，不是的，他就讲柴胡汤有这么种情形，如果下之后柴胡证不罢，可以与柴胡汤，没有问题的，但是有这么一个问题，发生冥眩状态，蒸蒸而振，然后发热汗出，但是病马上就好。

李冠杰：第 101 条在段落划分上也有点问题，第一部分：“伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具”。这是降一字格排版的条文。在《康平本》里这一条是一个单独的段落，在《宋本》里它和下边的条文共同合并为第 101 条。先看第 101 条的第一部分。

解读一下：

“伤寒中风”，意思是无论伤寒还是中风，不是说既有伤寒又有中风。无论是患者得了伤寒，或者得了中风，或者在这儿也可以把它理解成泛指整个太阳病而言。

“有柴胡证”，就是在表证的同时又出现了少阳病的症状反应，“有柴胡证”嘛。这里的柴胡证把它理解为阳性半表半里证就行了。这个地方明确地提出了“柴胡证”的概念，这是方证相应理论明确的一个阐述。在这个地方，把方证相应用“柴胡证”这种形式说得非常明确了。换一个角度来看，这就相当于以方剂的名称来界定疾病。这一点正是经方医学的一大特色。用方剂的名称来界定疾病，这一点很重要。

我们初学中医的人常常会碰到这样的问题，就是古人说的某一种病相当于现在的什么病？比如现在学习的过程中也经常提到，太阳表证放在现代疾病当中，有时把它简单地说成感冒。实际上，传统中医的好多疾病和现代医学的好多疾病是可以划等号的，叫的名字不一样，但是说的都是相同的东西，都是说的具体的某一个病变位置发生了某种性质的具体的疾病。但是，经方里面不是这样认识的。经方里面是用方证来划分疾病的，方证的名字就是方剂的名字，所以说这也是很大的一个特色。

至于它的正确性不止一次说过了，后面还要不断地说。所以，经方医学理论从这个意义上说，经方医学的病和现代医学的病是无法接轨的。比如刚才说的小建中汤，它对应的小建中汤证。有可能出现的疾病一大堆，这仅仅是统计到的医案，还有统计不到的，这是一个相当复杂的事情。而且方证和方证之间，小建中汤和小柴胡汤有一些疾病是重叠的，这就形成了非常复杂的一个问题。经方这个医疗体系治疗的是人体患病以后所表现出来的证，而不是具体的疾病。经方里面的证，是若干个具体的、有内在联系的症状，对这些症状进行科学的辨证分析之后，归纳出来的病理范畴，实际上这也是一种病。

凡是对经方体系比较熟悉的，马上都会提到这样的问题：如果经方理论是这样的，那么《金匱要略》里的病是什么意思？为什么《金匱要略》和《伤寒论》是同一本书，把它分为杂病这个范畴？这是因为辨证的基本理论、基本方法都在《伤寒论》里面讨论了。后面的那都是各有特色，如果把后面的全塞到六大类疾病里去，反倒又很乱。所以又用了一些疾病的部位，病变性质做一些线索去论述，但是辨证的方法还是要用经方方证相应的方法。这样再去理解《金匱》的杂病部分就好理解了。虽然《金匱》里说了好多疾病，但是它的意思不是让你去治疗这些具体疾病，它是让你运用经方辨证的思维来理解病理。其实临床中也是这样，好多妇科里面的疾病用在男性病人身上，有得是啊！所以它真实意思和实践证明，都不是那么机械的一个问题。

经方是对症状的科学分析有自己的一套分析方法。用经方的辨证方法归纳出来的疾病范畴，既不同于具体的疾病，也不同于具体的症状。虽然它来自于症状，但是它和具体的某一个症状反应还是有区别的，所以它是经方医学所特有的对整体病理状态的科学地界定。这个大家慢慢去体悟。

“但见一证便是”，如果仅仅从字面上来理解，应该说太阳病中只要有一个柴胡证出现，就可确定存在少阳病。但是细推敲，问题远不是这么简单，且不说少阳病里众多的或然症，仅仅说四大主症，四大主症里“默默不欲饮食”和“心烦喜呕”在其他类型的疾病里也是常见的，比如里证里面也常会有。所以对“但见一证便是”，也要客观地来看，不能机械地解读。“但见一证便是”在这里还应该有更深层的含义。从经方病理角度来看，三大类阳性疾病里面，半表半里证是最为特殊的。无论是太阳病还是阳明病，一旦有少阳病存在，整个疾病性质就发生变化了，包括治疗原则、治疗方法都得跟着变。比如太阳病得发汗，如果太阳病的同时伴有阳明病的话，可以先汗后下，它只是一个顺序的问题，顺序有所变化。但是一旦伴有少阳病的

存在，那就汗也不行、下也不行，“但见一证便是”的真正意思在于这儿。一旦确定了少阳证的存在，那就是很重要的问题了，整个的治疗原则、治疗方法都得跟着变。

“不必悉具”，少阳病的反应一般地都比较复杂，因为涉及的病变部位本身就比较复杂，只要有其中的主证存在，就可确定少阳病的存在，是这个意思。但是还应该包括另一层意思：就是确定有无少阳病存在，不需要四证俱全。这儿可以延伸，少阳证的四大主证与或然证其实并没有质的区别。为什么？四大主证“但见一证便是”，四大主证既不是单指的“往来寒热”，也不是单指的“胸胁苦满”，就是说这四大主证有一个，只要确定是少阳病的主证，就结了。为什么叫四大主证？条文里面写得很明白，把它做为典型的症状提出来了，后世把它叫四大主证。实际上，就是在少阳病里比那些或然证出现得频率高，实质就是这么一个问题。在实际临床中，真正的小柴胡汤证表现为四证俱全的，也非常少。

学完这一条后，也可以做一个延伸。经方辨证始终存在像这一条里说的这种规律。经方施治依据的是人体患病以后表现出来的症状反应，通过四诊和综合辨证之后，符合什么方剂的治疗范围，就把它称做什么方剂的适应证，在经方中简称方证。但是反过来说，具体到一个孤立的症状反应，任何一个孤立的、单独的症状反应，又都不能单独地做为确定方证的依据。

再换一下角度，假设把小柴胡汤证的主证和或然证都搜集全了，但是会凸显出另一个问题：所有的这些证绝不会同时出现在同一个人身上。这样就出现了一个问题，理论和临床实践存在着一个很深的矛盾。怎么去确定呢？一个单一的症状不能做为方证的依据，我想多找几个症状，在某一个具体病人身上又没有几个准确的证，病人得病不是按照书上去得的，这就是相互矛盾的。为了解决这个矛盾，也就是经方理论为了解决这种方证的整体表现不够稳定的特性，在经方里头

还有一套完整的病理辨证体系，这套病理辨证体系反过来就可以指导临床，你再去辨证就是明明白白的。

刚才大家听我说得比较抽象。为什么要强调这个？刚刚入经方之门的人，最容易犯的一个毛病就是盯在一个症状上。比如咳嗽这个症状在很多方证里都能出现，光是咳嗽不能确定或是表证还是半表半里证，大承气汤证还可能得大叶性肺炎呢！所以还得进一步地辨，那么，进一步怎么辨呢？咱们举一个例子，比如面前有一个桂枝汤证患者，他同时又有食欲不振、精神欠佳这些的疑似“默默不欲饮食”的症状，但是这类的症状在桂枝汤证和小柴胡汤证均可出现，甚至桂枝汤证里还会有呕的症状，都可能出现这样的症状。这个饮食、精神欠佳的情况一旦真正属于小柴胡汤的话，再用桂枝汤治疗就是错误的治疗，就不对了，也治不好。那么，凡是懂经方的人马上想到一个问题：我得确定有没有小柴胡汤证。确定有没有小柴胡汤证就成了问题的关键了，如果确定不了，你用桂枝汤吧，要是确定了，就不能用桂枝汤了，最大可能也就是一个柴胡桂枝汤的问题。怎么确定呢？我们还要通过四诊，再去找还有没有别的症状。我现在和同学交流，经常说的一句话：你去找还有其他的证没有。“默默不欲饮食”在这个地方已经成了一个疑似证了，有存在少阳证的可能，要是没有少阳证，那可能就是一个桂枝汤证，桂枝汤五味药就行了。但是，一旦有少阳病的存在，整个疾病性质就变了。那么，咱们再去找还有没有别的少阳证，比如口苦、胸胁苦满、往来寒热啊；像脉象偏弦细，像舌象舌苔啊都可以，你再去重新审视四诊的这些资料，不管哪一类的症状，只要是再找到一个，那就比较确切了。那么，再根据少阳病和桂枝汤证所占的比重，最终可以确定一个方剂来治疗。

通过这些大家能看到，病理辨证体现在一开始怀疑有少阳病，从何怀疑啊？从症状怀疑的，疑似症状怀疑有少阳病。因为有少阳病整个疾病性质就变了，这是一个关键的问题，一定要把这个问题解决了，

这整个的思路就是一个病理辨证的过程。下边再去找一些符合的具体症状，就是一个整体的辨析过程。在这儿，病理辨证就起到了一个方向指导的作用，这一点很重要。临床辨证当中，千万要注意这些事，特别是初临床的，比如不要轻易的认为有汗有热就是桂枝汤证，阳明病的白虎汤证完全有可能出现这种情况，麻杏石甘汤证也有可能出现这种情况。所以，你要再去找有没有确切的里热的情况，再去找有没有确切的表证的情况，然后才能解析开。

下边做个小结：无论是伤寒还是中风，如果同时伴有柴胡证，只要有其典型的症状反应之一，就可确定有少阳病存在，并不需要所有的柴胡证都同时出现。

下边是第 101 条的第二部分，在《康平本》里把这一条是分了两个段落的。

“凡柴胡汤病证而下之，若柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却复发热汗出而解”。这是降一字格的条文。

下边解读一下：

“凡柴胡汤病证而下之”，就是说对少阳病患者使用了泻下的方法，在经方里也是典型的误治了，因为少阳病不可汗、不可下。

“若柴胡证不罢者”，就是说少阳病虽然被误下以后，但是并没有发生其他类型的疾病，不单单是仍然有少阳病的疾病反应，同时还没有发生其他类型的疾病。说得具体一点，虽然用了泻下的方剂以后，包括下利的症状也没有了，就是又恢复了基本上完全是少阳病的一种症状反应。用今天的话说，就是疾病仍然保持在阳性半表半里证的病理阶段，没有发生质的变化。

“复与柴胡汤”，就是说仍然属于少阳病的范畴，治疗还需要使用柴胡汤来治疗。从这儿就可以看出来，少阳病和太阳病的治疗就有所不同了，古人把这个东西都弄得非常得详细。太阳病如果下了以后，以前就算是表实证的，经过泻下以后，也得用桂枝汤来治；但是少阳

病呢，仍然还用小柴胡汤来治。

“必蒸蒸而振，却复发热汗出而解”。这实际是一种服柴胡汤以后的瞑眩反应。这个“蒸蒸”是形容人体发热的那种状态，如蒸的那个样子，应该说热得程度比较重了；“而振”，是恶寒得严重甚至表现出来打寒战的样子；一方面其热如蒸，一方面恶寒严重，可见这个症状反应非常强烈。这个地方描述的症状有点像大青龙汤证，当然它不是一回事，病理上不一样，但表现就很像。

“却复发热汗出而解”，这是服小柴胡汤以后，在一定的条件下可能出现的一种特殊的反应过程。临床中此类的瞑眩反应，并不一定出现在误下之后，在某些特定的情况下服了小柴胡汤，也常会出现瞑眩反应。

比如像发热，一般的是发热以后就会出汗，然后病就解除了。这个在临床中是常碰到的，一个是小孩子体弱多病的，往往得小柴胡汤证的机会非常多。比如感冒了，吃饭不好，大便还有点干，然后又老发脾气，老闹，常常伴有发热，这样的大部分都是小柴胡汤证。如果是体格比较健壮一点的，小柴胡汤服一次就好了；如果体质比较弱的，服了小柴胡汤以后，往往出现最多的就是发高烧。我曾经有一个病人，大概三岁的小女孩，服了小柴胡汤。那个时候比较早期了，我用小柴胡汤的量比较大，将近 10 克，现在想想有点后怕。孩子喝了以后，当天晚上烧到 40 多度，把她奶奶爷爷吓坏了，结果半夜十二点以后出点汗就好了。

关于服药以后的瞑眩反应，我结合自己临床中的体会，跟大家说明以下几点：

- 1、这个应该是常识性的，并不是说所有服小柴汤的人都会出现瞑眩反应。

- 2、瞑眩反应也并不是只有少阳病才有，其他类型的疾病也可能出现瞑眩反应；但是，特别是服小柴胡汤，在小柴胡汤证中出现的瞑

眩反应的机率比较高，就是说方证相应，小柴胡汤证给的也是小柴胡汤。像“发热汗出而解”像这类情况比较多。

3、瞑眩反应也不只是发热汗出一种形式。我就用小柴胡汤治过一个年龄比较大的人，三十多年的胆囊炎，而且小柴胡汤证几乎维持了三十多年，平时经常口苦、身上经常往来寒热、消化不好、鸡肉都不敢吃，四大主证差不多都有了。这三十多年里，其实治也不止一次了，就是没有碰到用经方的人。我就给他小柴胡汤，吃了之后就出现了瞑眩反应，他说：“我昨天晚上喝了小柴胡汤以后，一开始腹部左侧开始疼，之后这个疼慢慢往下移动，从上腹部移动到下腹部，然后开始发热，渐渐这种疼痛再往下走，就开始到腿上了，越疼越往下，后来一直到了小腿，慢慢地就开始往下热，热过去以后疼痛就消失了，闹了多半宿，我也感觉轻松很多了”。这也是一种比较特殊的瞑眩反应，因为病的时间太长了。

其实，这个条文里论述的也是这一类情况，就说人相对比较弱的才会出现这种情况。但是在实际临床中，其他类型的疾病也存在瞑眩反应。下面和大家说几个出现瞑眩反应的医案。

有一个病人，服的是真武汤，他年龄比较大，病程也比较长，症状反应也比较突出，体质很弱，因为他上车都有困难，他孩子就把我接到他家去给他看。他就在院子里房门口坐一个马褥子晒太阳，如果想解小便，常常走不到厕所，到院子中间就憋不住了。真武汤证也比较明显，头晕，浑身无力。结果他服了真武汤以后，睡了两三天，把他老伴吓坏了，叫都叫不醒，一直在睡。这是一个比较典型的瞑眩反应。

还有一个是八十多岁的老太太，她是脑积水。我给她看了以后，给她的方子是当归芍药散合真武汤，刚开始服药的几天，每天下午有二十多分钟的近似休克，人事不省，要二十多分钟以后才过来。实际上这也是一种瞑眩反应，她过了以后什么事都没有，好人一个。这种

眩晕反应很吓人，但要在病理上想想，这也很正常，因为她本身就是脑部的一些疾病，如果方与证相对了以后，出现这种眩晕反应也不足为奇。

还有一个病人，服了小柴胡汤合当归芍药散合桂枝茯苓丸之后，她出现困倦，近似于嗜睡。我跟她说要多休息，想睡就睡。结果睡了两三天，她不是老在睡，就是嗜睡的那种情况，两三天的时候就过去了，之后就感觉好多了。

还有服生姜泻心汤出现腹泻的。生姜泻心汤本身就治腹泻，但是服了以后，反倒会出现腹泻，甚至狂泻不止，泻完了然后就好了。

下边作一个小结：凡小柴胡汤证而误用泻下的方法治疗之后，如果患者仍表现为小柴胡汤证的话，还要用该方治疗，但是有可能出现蒸蒸而振，发热汗出之后而病愈的情况。

伤寒二三日、心中悸而烦者、小建中汤主之、（102）

胡希恕：那么小建中汤也不光治肚子疼，那么伤寒二三日，表还不解呀，但是中虚，血也少，血不足养心，心才悸，心中悸，悸就是跳。这个血少不足以养心而心中悸。表不解这就补充上边这个小建中汤，不是光治肚子疼，小建中汤治腹痛那是如神，那非常好使。那么无论是虚寒性的胃溃疡，或者其他一般的腹痛，小建中汤都好使。但是小建中汤是由桂枝汤证而来的，它也解表，如果中虚有寒，血气不足，这种表不解可以用它。那么证候呢就是心中悸而烦，一般表证心都不悸。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边是顶格的条文。

解读一下：

“伤寒二三日”，我们可以理解为表证的初期。“心中悸而烦”，这实际上是两个症状，“心中悸”，心中悸动不安；“烦”是精神上

的一个症状，精神上感觉烦躁。这两个症状在其他方证里面也可能见到，需要结合治疗方剂，对病理进行具体的分析。

这个方证的“心悸”，实际上是由于里虚有寒，津血两虚，致使循环系统失养比较严重而造成的。小建中汤里边的“腹痛”，也是这么一个病理，都是因为里虚寒造成一些胃肠功能不佳的一种状态。这儿论述的心悸，实际上就是整个循环系统失养，必须加快心脏的跳动起到一个补偿代偿的作用。

“烦”这个症状常常热证里边才有，小柴胡汤证里边也有心烦，但是小建中汤证的“心烦”跟热证的“心烦”在病理上有质的区别。这儿的“心烦”是一种虚证造成的，它不是因为热，而是因为虚寒证造成的。

从病理上分析，这一条它所论述的是一种本来就有里虚寒证，并且以肠胃功能低下为主要矛盾面，因为肠胃动能的低下营养不足，造成人体虚弱，同时这个时候，又患有阳性表证，这么一种病理状态。

根据经方的治疗原则，像这种情况不能单纯的去发汗解表，应该先温里，所以用这个方剂来治疗。跟这个方剂在病理上比较接近的就有一个桂枝人参汤，相比较的话这个方剂有血虚的因素存在，我们其实仔细看一看药物组成的话，虽然说从大的方向上来说都是里虚寒，但是有所不同，那个里虚寒是干姜能够治得了的，这个里虚寒干姜治不了，得是饴糖来治，毕竟它们还是有区别的。

下边作个小结：患太阳病两三天时间，患者出现心中悸而烦的症状，为小建中汤主治之证。

大阳病十余日、过经①·反二三下之、后四五日、柴胡证仍在者、先与小柴胡汤②、呕不止、心下急、郁郁微烦者、为未解也、与大柴胡汤、下之则愈、（103）

注：

1. “大阳病十余日、过经”《宋本》作“太阳病，过经十余日”。

2. “先与小柴胡汤”《宋本》作“先与小柴胡”。

柴胡半斤 黄芩三两 芍药三两 半夏半升洗 生姜五两
切 枳实四枚炙 大枣十二枚擘

右七味、以水一斗二升、煮取六升、去滓、再煎、温服
一升、日三服、（注）一方加大黄二两·若不加·恐不为大柴胡汤·

胡希恕：太阳病已经十来天了，“十余日”，他也就暗示已经传入少阳而为柴胡证了。“反二三下之”，那么大夫不知道用柴胡汤，而反一再吃泻药，“二三下之”嘛，到四五天的时候了，就是泻下两三天，接着不就是四五天嘛，“柴胡证仍在者”，这个仍在者，可见经过十余日的时候柴胡汤证就发现了，所以他这个文章都这样子。那么经过十余日，我方才讲，已经传到少阳，怎么知道的呢？这句话就知道了，“柴胡证仍在者”。那么也就是说太阳病在十余日的时候，已经传入少阳而发生柴胡证了，那么这个大夫不知道用柴胡汤，他反二三下之。那么下后了，到第四天、第五天了，柴胡证还不差，没因下而罢，还仍然存在，那么这个时候呢先与小柴胡汤，还是柴胡证嘛。但是由于这个误下，把半表半里的邪呀，大部分都引入到里去了，他病于里了，所以表有邪，你吃泻药，虚其里，中医讲这句话嘛，“邪之所凑，其气必虚”，里虚了，这表邪也趁里虚而入里。半表半里少阳病，在半表半里，没到胃肠里头呢，吃泻药，也虚其里，半表半里之邪也陷于里，这个就是的。

虽然柴胡证仍在，但是已经病于里了。先与小柴胡汤，呕还不止，心下急，这个心下就是胃这块，胃这块儿实得厉害，心下坚痛，又硬又疼，甚至于不可触按，那是胃实得厉害。心下急就是觉得这块痞塞不通，痞塞，急。急这个字，急是紧啊，里头没有地方，感觉外边急，心下这个部位不是。所以注家对这个“急”注解是很多了，李东垣说

是心下急就是那块儿不宽绰，不宽快，这也通，反正，这个急呀就是不通，觉着这个地方小，不宽快，就像挺肥个人穿个小衣裳，紧，不宽绰，所以叫做心下急，也就是里实比较轻微的，不到大承气汤那个心下硬还疼，不到那个程度，只是心下急而已。“郁郁微烦”，也不像阳明病那个烦躁得厉害，郁郁也就是默然，烦得不太重，说明这个病陷于里，里不是那么个实法，所以他不用承气汤。“为未解”，虽然与小柴胡汤，旁的证都解了，“呕不止，心下急”还存在，这个病还是没好呢，应该与大柴胡汤，下之就好了。半病于里也，这就是由半表半里由于吃泻药，而又病于里，就是少阳阳明并病。

那么为什么吃小柴胡汤而呕不止呢？大柴胡汤这个呕比小柴胡汤这个呕原因更复杂，小柴胡汤这个呕只是胃里头有停饮而已，有热激动胃里头的停水，所以往上逆呕。大柴胡汤两个问题，一个与小柴胡汤这个原因同时存在，另一个关键是大便下不去，气不得下行，都往上攻，所以心下急呢，这个呕只是用半夏、生姜是不行的，你还得想办法通大便，导这个气下行，这个呕才能除。所以大柴胡汤与小柴胡汤都有呕，但是大柴胡汤这个呕用小柴胡汤不行，呕不止，因为什么？心下急解决不了，非用枳实、大黄不行。本来是小柴胡汤证，由于大夫误治，二三下之，把这个邪又引到里头去了，那么小柴胡汤证还存在，但是大柴胡汤证已经就有了，所以吃小柴胡汤那是对的，不是错误，但是由于呕不止，心下急，这还有一半没治，还得吃大柴胡汤泻下就好了。

大柴胡汤与小柴胡汤的药物组成是不同的，没有人参了，大柴胡汤把人参去了。由于呕得厉害，生姜加量了，你看生姜是5两呀。由于心下急，他搁枳实、芍药，芍药也有点缓下的作用。那么另外呢应该有大黄，这个书上大黄没搁，不对，有大黄，大黄2两，应该有，方后注的有，他说“上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎（取三升），温服一升，日三服。一方，加大黄二两”。他说还有一

个方子是有大黄的，“若不加，恐不为大柴胡汤”。这是林亿他们在后头注的。所以这本书有些错误，那么缘起这个本不是一样的，有的本没大黄，有的本就有大黄。这个本就没有了，其实应该有的。你看看小柴胡汤搁人参，为什么？在小柴胡汤这个阶段啊，这个病由表往里传，就因为里虚，血弱气尽，所以加人参。加人参两种意思，一个由于里虚嘛，加人参使着病不能再往里传，同时也扶助正气驱邪。这个大柴胡汤就不然了，这病已经进到里头去了，里实了，里实是病实了，那么这个时候你再补里不行了，你补里了，就像咱们现在比方就是关门抓贼，你得想法去病了，病在那块你补那块就不行了，所以这块儿非去病不可，这个人参反倒碍事了，不能搁。他搁枳实、大黄、芍药，这是必要的。所以那个地方虚，邪没到那你要补，邪已经来了，邪在那成实了，你非驱邪不可，那你还补什么，补了，越补病越实，那就坏了。所以大小柴胡汤的药物不同，主证则各异。头一个，小柴胡汤这个阶段，胃里头一点病没有，邪没进到胃里头去，那么加强胃气，使得邪不往里头波及，而且扶正以去邪，那是对的。邪已入于里了，你再补里就坏了，补里也是补邪了，所以这阵儿非去邪不可。邪去了，邪一去，病治了。所以这个用药是不一样的，我们在临床上也是这样的。所以这个表证，表实的非攻表不可，不能用补药，这个我亲身遇到过，这也是年头很多了，也是个挺有名的名医呢，遇到一个咱们现在说就是温病啊，那热得很，他给人吃的就是银翘散这类的药，同时给加鲜生地。北京早先有个陋习，爱用鲜生地这个药，说解热。那个不行，它是补药啊，是强壮性的一种寒性解热药，那当时这个表实证的时候你搁上就不行，所以这个人啊后来这个病用得相当得重，就这个生地，他用得相当的重，用了 8 钱吧，我记得，后来我给看的。所以这个表实，你攻表，补药是用不得的。里实，病实于里，也不能够补，所以里实证这个实都是这么实的，我跟你说说。病实人虚了，这就坏了。你是补，这个病不受补了。攻病，人受不了了，这要

死人，我们讲阳明病的时候就有了。阳明病的死呀，他这个本病的病实，一攻就好，所怕在哪呢？怕人虚，人虚得厉害了，那你动不得手了，所以这个阳明病有急下证嘛。这个病来得非常的猛劲，非及时攻下不可，稍一延误，这个人体力虚衰得厉害，这个病来得非常的猛，这就是不能救治了，你再攻人受不了，这后头讲的。

在这我们讲的大小柴胡汤的问题，大柴胡汤为什么，病传进去，当然人也虚了，为什么不搁人参呢？搁不得。这个贼进屋子了，你把贼得撵出去，关上门子还行嘛？关上门好，它和你拼了。这是用药的一种规则呀，你看古人这个方剂就明白了。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边是顶格的条文。

在这里边有两个字的旁注内容，应该在“太阳病十余日”之后。但是在《宋本》里边，是“太阳病过经十余日”。《康平本》和《宋本》一比较，显然就是将这个旁注内容篡入正文的时候，改成这个样子的。要是如果从字面的意思上来理解的话，这样的改法就对原文产生了非常重大的影响。

你看原本本来的意思是“太阳病十余日”，就是说太阳病十余日的时候，就已经“过经”了，加这么一个旁注。但是，一旦把这个旁注篡入正文的时候，加在了“太阳病”之后，这个整体的意思就变成了患太阳病过经之后十余日。与原文的意思就相去甚远了。

再就是条文中的“先与小柴胡汤”，在《宋本》里呢，是“先与小柴胡”，显然是漏抄了一个字。

下面呢我们解读一下：

“太阳病十余日”，就是患太阳病已经比较长时间了，暗含有少阳病的意思。因为条文里边有相关的论述，暗示疾病已经发展了。

“过经”是个旁注内容，是后人加的。“过经”是指：邪离本经，传入它经，名曰“过经”。实际上这儿还是指的太阳病就是人体的太阳经，足太阳膀胱经受邪，“过经”放到这个条文里边，足太阳膀胱

经传到了足少阳胆经。

那么正确的解读呢，就是因为病期太长，人体抗御病邪的能力在与致病因子抗争的过程当中处于劣势，那么疾病由太阳经病进一步发展为少阳经病，正确的解读应该是这么一个样子。但是经方的本身的意思就是太阳病变少阳病了，大家看《康平本》就很清楚。实际上太阳病不应该存在这个“经”的问题，这个“经”是后来人总结的，起了和《内经》经络相同的名字，后人就把它理解为“经络”之“经”。所以说就产生了六经辨证。但是《伤寒论》里边，分的是有着内在联系的不同几个大的症状群。疾病性质不同，每一个症状群中的症状之间又有着内在联系。比如“脉浮、头项强痛而恶寒”这一类的疾病，就是最浅表的疾病，以这种症状反应出来的病理状态，就可以用发汗的方法来治疗。所以，就跟“往来寒热、胸胁苦满”这类的疾病，有质的不同，所以一定要分开。分的是以症状反应形式反应出来的病理状态，而不是具体的部位。一定要跟那个病变位置分开，这不是病位。大家记住这一点，这不是病位。

等我们下一周讨论经方辨证体系的时候，表、里、半表半里这些，我用的是疾病类型，而不是用的病位，大家这一点一定要弄清楚。它跟病位有比较密切的联系，但疾病类型不是病位。

下边，“反二三下之”，这个地方不管是太阳病也好，或者后来发展成了少阳病也好，施用下法治疗，显然都是误治。

“后四五日”，这个地方也挺重要，服了泻下药之后四五日。在这个条文里边，具体有两层意思：一个是虽然喝了泻下药以后，已经好几天了，疾病仍然没有痊愈；第二层意思就是下后四五天，疾病有点虚实错杂哪。

再往下，“柴胡证仍在者”，这个“仍”字本身就寓意着前边“太阳病十余日”，已经发展到柴胡证了，就是在下之前就有柴胡证了。虽然经过误下，但是疾病并没有发生质的变化，仍然处在少阳病的阶

段，还是少阳病，这是一种比较特殊的情况。

那么在这样的情况下，应该怎么治哪？“先与小柴胡汤”。为什么先用小柴胡汤？一个是刚刚服过泻下药不几天，人体必然会有虚的因素存在；第二个，中医里面有这样一句话，“下不厌迟”。“柴胡证仍在”，先用小柴胡汤把少阳病的病势减一减，然后再用大柴胡汤治疗。这里说的，特别有点像一个医案，说得很具体。

但是服了小柴胡汤之后，仍然还有一些症状，“呕不止”。小柴胡汤本身就有治疗“心烦喜呕”的功能，本身就能够治“呕”。但是服了小柴胡汤之后，反而出现“呕不止”，这说明还有其他的原因。什么原因？有里实的因素存在。临床当中应该有像大便不通之类的症状存在，出现了实证。

“心下急”，这是一个病症名。指的就是心窝这个部位拘急疼痛，或者有窘迫难耐的一种感觉。另外有注家形容成胖人穿瘦衣服，这个比较形象。《金匱要略》条文里边，大柴胡汤证临床当中还会表现出“心下按之满痛”，实际上这个症状和“心下急”同样都是里实证的反应。只是四诊的形式不同，所以论述的方式也不同，应该说是一个证，或者说程度上稍微有点差异。“心下急”是问诊得来的，胃里有什么不舒服吗？但是这个“心下按之满痛”是腹诊得来的，“按之满痛”是病人的自我感觉。其实在临床当中医生还有另一种感觉，就是心下这个地方按着有点抵抗感，有的还比较明显。就是这地方按着硬，一按就疼，感觉里边满，有的，这个地方像结住那么硬，整个胃这个地方就是比较饱满。按着比平常人的肚皮稍微抗手的感觉，没有正常人那么柔软。而且，往下按问他觉着满吗，觉着不舒服，这是很明显的。

大柴胡汤证，四逆散证，这是经常出现的。

前两天有一个人，也是这个症状。他是咳嗽，找不到其他的明显的症状，只是说吃东西有时候会噎，有时候胃口这地方热，另外还有

咳嗽。后来我就给他做了下腹诊，心口这地方一按他就明显得疼，但是这个地方还不硬，挺柔软的，最后我给他小陷胸汤。小陷胸汤也有这症状，“正在心下按之则痛”。给他小陷胸汤合上栀子豉汤。这个就是症状和症状之间的一个交错了。这个“心下按之则痛”，这要比较柔软的话，病人也不感觉里边满，在这里有可能是小陷胸汤证。如果按的时候，也觉得满硬，他自己也觉得满痛，那么多半是里实证，有柴胡证的话，那么就是大柴胡汤证或四逆散证的机会就比较多了。

“郁郁微烦”，这是服了小柴胡汤之后，“心烦”略有缓解，但是又没有完全好。这个地方为什么这么理解？大柴胡汤证也常常会有“心烦”，如果里实得严重的话，病人“心烦”的程度，绝对不亚于小柴胡汤。“郁郁微烦”，就是他前边服了小柴胡汤，有了应验。

这儿呢，再跟大家说一个这几天的一个医案。有一个临近县的老太太，输液输来输去，心乱、心悸，难受得实在不行了，来我这儿了。当时病人的症状表现啊，就是“叉手自冒心”，很明显就是那个症状。她坐在我面前，用手抚着心口这儿，说我心慌啊，不行了，有点上气不接下气的样子。摸摸她的脉，稍微偏一点滑，要如果数的话，不超过 80 次，数也不厉害。我就开始找别的症，就在这个诊断的过程中，随她来的人就跟我说，说她呀，这一段时间心情不好，她老伴这段时间刚刚不在了，她老觉得对不起她老伴，就一直心情特别不好。看她当时烦得坐都坐不住，初看到的时候，你最容易想到的就是桂枝甘草汤证，再加上她的心理因素，她是桂枝甘草加龙骨牡蛎汤证。我又再仔细问她，因为她心率一点也不快，后来找到的症啊，一个是大便四五天不解，解得时候比较干，这是其一；另外一个呢，我给她做腹诊，摁她肚子，觉得满得慌，这就是明显的一个；另外一个口苦。有这三点我这个证据就全了。给的是什么药呢？就是大柴胡加龙骨牡蛎汤，就是说把柴胡加龙骨牡蛎汤的小柴胡汤改成大柴胡汤。因为她就心慌的那个样子，我就给她采取了一个比较特殊的办法。我说这样

啊，我给你把药泡上，你马上就喝，喝完了以后，你过一你可能会缓解一点，然后你再走。对她来说现在这会儿也没法走，走不了。那就在这等着吧，这也等于说是救急啊。大柴胡汤加上龙骨牡蛎加上茯苓我把茯苓用的量稍大一些，龙骨牡蛎，铅丹就免了。我给她泡了大概3克左右。这3克左右我给她用开水泡好了，让她喝下去，大概有十来分钟吧，十来分钟之后，就看她在那沙发上坐着，逐渐地手就拿下来了，然后慢慢地就开始跟别人聊天，从那个喘气比较急促，精神比较紧张的，慢慢看着就缓和下来了。过了二十多分钟吧，就明显得好多了。

下边，“为未解也”，服了小柴胡汤后，还有柴胡证存在，说明少阳病还没有解除，而且又发生里实证。

后边的“下之则愈”，就是进一步的说明。

联系其他条文的话，就比较容易理解了。第136条“伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者与大柴胡汤”。跟这一条论的，是非常接近的，也是表证十多天出现了里热。那个没有经过下，这个是经过下了。但是在那条里边就列举了“往来寒热”的症状，这儿虽然说没有列举啊，我们应该想象到他应该有典型的半表半里证。

大柴胡汤证的病理：阳性的半表半里热证，合并里实热。

下边呢，做个小结：患太阳病十多天的时间，发生了少阳病的症状反应，医者反接二连三地使用泻下的方法治疗；又过四五日后，患者仍然表现为少阳病的症状反应的，可先用小柴胡汤治疗；服药后如果表现为呕不止，心下急，郁郁微烦的，为少阳阳明合病，再用大柴胡汤下之就可治愈。

下面咱们再看看方子。大柴胡汤由8味药物组成：柴胡、黄芩、芍药、半夏、生姜、枳实、大枣、大黄。这个方剂实际上就是在小柴胡汤的基础上，去掉了有补虚作用的人参、甘草，因为它没有虚证，它对的是里实证。这两味药不太适宜，就去掉了；因为有“呕不止”，

加大了生姜的用量，由以前的三两增加到了五两；另外增加了芍药、枳实和大黄。芍药有治疗腹满，腹痛的作用，所以大柴胡汤也有治疗腹痛的作用，同时芍药有缓下的作用，可以治疗腹满。枳实行气消胀，与大黄同用，我们可以把它看作是半个小承气汤。所以这个方剂就有较强地去里实的作用。大黄这味药，在《康平本》和《宋本》当中都没有，但是《金匱要略》里，大柴胡汤就有大黄二两。所以王叔和特别在方后，加了一个注解：“一方加大黄二两，若不加恐不为大柴胡汤”。

下边呢，是大柴胡汤的方证和现代应用。

症状：便秘、胸胁苦满、恶心呕吐、往来寒热、腹痛、口苦咽干、食欲不振、小便黄赤、烦躁，这是主要的。还有腹胀、口渴、眩晕、自汗、头痛、肩颈酸痛、黄疸、下利等症状。

舌质：红舌、绛舌、舌干燥较多，舌尖有齿痕、淡紫、淡胖、有瘀点、中裂、紫暗，这都是 1 例。

舌苔：黄苔包括黄燥、黄腻、黄厚；白苔包括白厚、白腻、白燥；黄白相间；灰黑有芒刺。

脉象：弦脉、数脉、沉脉、滑脉、细脉、弱脉、微脉、结代脉，还有弦滑脉、弦数脉、弦大脉、弦实脉、弦长脉、弦洪脉，以弦脉为主。

下边是现代应用：

肠伤寒、流行性感冒、流行性脑炎、细菌性痢疾、无名高热、肺炎、气管炎、支气管哮喘、支气管扩张、肺气肿、心膜炎、内膜炎、风心病、冠心病、心绞痛、心肌梗死、心包炎、肺心病、动脉血管硬化、高血压、脑溢血、脑软化、急慢性胃炎、肠炎、胃及十二指肠溃疡、胃扭转、胆汁反流性胃炎、胃痉挛、胃酸过多、胃癌、胃嗜食、幽门不全梗阻、胆囊炎、胆绞痛、胆道蛔虫症、胆结石、胰腺炎、阑尾炎、肠炎、结肠炎、肠梗阻、肝炎、肝硬化、急性黄疸型肝炎、病

病毒性肝炎、肝脓肿、亚急性肝坏死、习惯性便秘、急慢性肾炎、肾结石、尿道结石、肾盂积水、急性肾盂肾炎、肾萎缩、阳痿、糖尿病、肥胖症、半身不遂、肋间神经痛、神经官能症、癫痫、神经衰弱、失眠症、三叉神经痛、美尼尔氏综合症、帕金森氏综合症、角膜炎、虹膜炎、耳鸣、急性化脓性扁桃体炎、精神抑郁症、急性精神病、非典型性精神病、出血热少尿期、经期咽喉肿痛、急性乳腺炎、闭经、急性盆腔炎、前列腺炎、尿道狭窄、肾周脓肿、脑血管意外、颅内血肿、过敏性紫癜、血管神经性头痛、荨麻疹、流行性出血性结膜炎、猩红热、丹毒、疟疾、传染性单细胞综合症。

所对应的疾病非常得多，当然都是有大柴胡汤证才能治愈。

另外，大柴胡汤在临床上是一个很常用的方剂。我想到了一个医案，有一个 21 岁的小姑娘，她在工厂里上班，她无名低热烧了一个多月了，输液啊，中药啊，什么都使了没有疗效，老是好不了。后来也不能上班了。后来，来我这儿，我给她诊断以后，她就是一个大柴胡汤证。我就给她大柴胡汤，我给了她七天的药。后来他爷爷来说，她吃了两天，就好了，就回去上班了，再不吃药了。结果就剩了 5 天的药，这是一个医案。

另外一个，大柴胡汤合桂枝茯苓丸，这个方剂我们可以把他固定下来，当做一个常用方剂。大柴胡汤和桂枝茯苓丸里面只有一味药是重复的，芍药是重复的。在临床当中你可以相加，把两个芍药加在一起，这样芍药用量大。他有抽筋或眼比较干你可以相加，如果没明显的芍药症的话，你也可以取大量，取一份就行了。这个方剂比较突出的功能就是治疗心脏病。但不是说所有心脏病，有柴胡证的像心绞痛、心肌梗塞这一类的病，用这个方剂救治效果非常好。但前提条件得有柴胡证，有瘀血。为什么治心绞痛非常好呢？这个方剂里面有桂枝、枳实、生姜，这是一个方剂，就是治疗胸痛的。所以说这个方子治疗心脏病。但是实际治疗当中，还不仅仅是治疗心脏病的问题，甚至包

括一些像乳腺增生之类的，包括脸上的色斑，前提条件就是要有这两个方证，你得有瘀血有里实有柴胡证，疗效非常好。

在这儿呢，我也跟大家说两个医案。其中一个 40 多岁的男性病人，他外表还是五大三粗的，挺壮的一个人。但是他心脏病很厉害，他当时来我这里看的时候，你要让他自己走，走不了 200 米就不行了，平常走路心脏就受不了。医院让他去济南做支架，他不敢做。就来我这儿，我就给他大柴胡汤合桂枝茯苓丸；他大便如果溏的时候，就四逆散合桂枝茯苓丸；热得厉害的时候，有时中午躺那儿睡不着觉，特兴奋，脉又数又大，会加石膏。就这样前后大概吃了两个多月的药，就彻底好了。现在二三年了吧，再没有因为看病来过我这儿，一直很好，时不时的会碰见，这是一个。

还有一个老太太，住在德州，她的女儿在这儿，看病看得挺好。就说呢，我妈心脏病，然后问了问呢，我说这样吧，在电话里问一下，电话里她有明显柴胡证，然后有时候胸痛啊，症状也比较明显，年龄挺大的了，70 多岁了。后来我给她弄药，发过去。有意思的是，她看了以后，给姑娘打电话说，他的药我不敢吃，她说他的药里面是什么啊？他弄了一些药粉我也不知道是什么，让我每次吃一小袋一点，我不敢吃，那我要中了毒怎么办啊？后来她姑娘给她解释说，我一直在这里看病，人家这个医生说人体有自愈能力，你别老靠这些西药。她一听这些话儿，这老太太是有文化的人，她说，你别说了，我马上去吃，现在就吃。结果他吃了有两个多小时，她跟她姑娘打电话过来了，她说我感觉吃了药以后轻松多了，而且饿了也想吃饭了。她吃了几天，症状就明显得没了。过了有一年多，后来来了还是吃的这个药，换了一次四逆散合桂枝茯苓丸。这个方剂我觉得应该把他固定下来。我们现在的人，特别是有一把年纪的人，得这种病的人还是挺多的。

伤寒十三日不解、胸胁满而呕、日晡所发潮热、已而微利（注）此本柴胡·下之而不得利·今反利者·知医以丸药下之·潮热者实也·非其治也·（经）先宜服小柴胡汤以解外、后以柴胡加芒硝汤主之、
①（104）

注：《宋本》此条文如下：

伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利，此本柴胡证，下之以不得利，今反利者，知医以丸药下之，此非其治也。潮热者，实也，先宜服小柴胡汤以解外、后以柴胡加芒硝汤主之。

柴胡二两十六铢 黄芩一两 人参二两① 甘草一两炙 生姜一两切 半夏二十铢洗本云五枚 大枣四枚擘 芒硝二两

注：“人参二两”《宋本》作“人参一两”

右八味、以水四升、煮取二升、去滓、内芒硝、更煎微沸①、分温再服、（注）不解更作·②

注：

1. “更煎微沸”《宋本》作“更煮微沸”。
2. 《宋本》此处有林亿等人所加按语如下：

臣亿等谨按：《金匱玉函》方中无芒硝。另一方云，以水七升，下芒硝二合，大黄四两，桑螵蛸五枚，煮取一升半，服五合，微下即愈。本云柴胡再服，以解其外，余二升加芒硝、大黄、桑螵蛸也。

胡希恕：“下之以不得利”，这个“以”是错的，应该是“而”，把“以”改成“而”字对。本来是太阳伤寒，已经十三天了而不解，当然这个病是传入半表半里，而又系于里了。“胸胁满而呕”，这是柴胡证，传入少阳，所以胸胁满而呕。“日晡所发潮热”，这是阳明病。日晡所就是日将暮的时候，古人说就是申酉时了。这个胃里头要是实，热结于里，常在日暮所的时候特别发热。这个潮热啊也有两种解释，古人把潮热解释成什么呢，解释一个定时，日晡所嘛，在这个定时来热叫潮热，不对的。这个潮热就是其热如潮啊，潮热它厉害，其势来得汹涌，阳明病就是这样子，这个热，其热如潮。它要日晡所

发热谓之潮热，那它就不叫日晡所发潮热了，所以两种说法还是我后头说这个对的，潮热就是其热汹涌，所以阳明病蒸蒸发热，蒸蒸，这个热从里头往外蒸，蒸蒸发热。“胸胁满而呕”，说明病已传入少阳而为柴胡证。“日晡所发潮热”呢，病由半表半里又传于里了，而有阳明病的这种情况了，所以日晡所发潮热。“已而微利”，“已而”两个字也是多的。“日晡所发潮热，微利”，在《玉函经》上大概都是“微利”，没有“已而”。“已而”就是然后，就是日晡所发潮热之后下利，这么讲也行，不是不行的。但是这个意思呀，就是既有胸胁满而呕、日晡所发潮热、微利。这个微利也是阳明病啊，它是热利呀，可是在这地方还不知道是热利，底下有解释，这个是吃错药的关系。那么根据上面那个胸胁满而呕，日晡所发潮热，这就是少阳阳明并病，就是我们方才讲那个，既有少阳病，又有阳明病，就是少阳阳明并病，也就是大柴胡汤证。这个微利一会儿再讲，现在先不要讲。

“此本柴胡证”，那么胸胁满而呕，日晡所发潮热，这是少阳阳明并病，就是少阳病没完，阳明病就发生了，所以日晡所发潮热，那么这是大柴胡汤证了，这个“此本柴胡证”就指着大柴胡汤证说的。而用大柴胡汤下之不会得利的，下之而不得利，这个下之就指着用大柴胡汤。“今反利者”，那么现在微利是为什么呢？在这提到微利了，“知医以丸药下之，非其治也”，这是由于这个微利不是这个本病应该有的，就是即便吃了大柴胡汤也不会微利的，这是医以丸药下之，是非法的治疗。这个丸药下之指着温性泻药，指着巴豆，古人常有这个巴豆下剂。这个巴豆是热，本来是个热病嘛，吃巴豆哪行，所以非其治也，但是巴豆的泻下非常地剧烈，所以药后啊，这个丸药一半时是不完的，这个人还是有微利，它是这么来的，这是非法的治疗的结果。

那么现在这个病人还潮热，说明还是里实，那么当然还是有胸胁满而呕了，他既有柴胡证又有里实证，还是少阳阳明并病了，可是他吃过巴豆了，里虚了，他微利，那么这时候大柴胡汤不大怎么适宜了，

要缓一缓，“先宜服小柴胡汤以解外”，先治这个胸胁满而呕，这个少阳共里来说，少阳在外，阳明在里，这个外不是解表了，这是指着少阳与阳明这个位置上来说的。“后以柴胡加芒硝汤”，那么然后用小柴胡汤加芒硝去潮热。这个胃家实呀只是实、满、胀，不用芒硝，只用小承气汤就行。有潮热，你非用芒硝不可。这个芒硝共这个石膏都是大寒药，解热，那么这个大黄呢也不能说不去热，但是解热的力量照芒硝差得多，所以他不用大柴胡汤，这个时候就因为泻下之后，人虚了，还以小柴胡汤的基础上加上芒硝，通其大便，解其潮热就行了。这个柴胡加芒硝汤也是小柴胡汤的基础上，就因为吃完泻药之后的关系，不然的话就是用大柴胡汤就可以，那么如果热甚，可以加石膏。那么这个方子就是小柴胡汤，柴胡、黄芩、人参、甘草、生姜、半夏、大枣，这不就是小柴胡汤嘛，另外加上芒硝。

这个份量啊，你们看这个份量与原方不同了，古人是这么用的，把小柴胡汤煎出来了，吃一煎，吃二煎，最后那一煎，古人一煎三剂，他吃了两次，最后那次加上芒硝，就是这个份量。就是柴胡证啊取三分之一加芒硝，先用小柴胡汤。我们现在用呢，就是小柴胡汤里头加芒硝。可是应该先吃小柴胡汤，先服小柴胡汤，你先不要加芒硝，小柴胡汤吃完了，你再另开一个加芒硝的。古人这个方剂的药量啊不是把这个量缩小了，他那个一煎三剂，一剂是分三次吃，吃了两次，最后一次，一回吃一碗啊，一升嘛，把那一碗药留着，后来他搁 2 两芒硝，再拿锅温温，他是这么一个办法。所以这个方子就治小柴胡汤证，大便不通发潮热，上八味，以水四升，煮取二升，去滓，内芒硝，更煮微沸，分温再服。不解，更作。你看后头写的，这八味药，以水四升，煮取二升，把渣子去了，然后搁芒硝，是芒硝都要这样，芒硝不要煎，可是搁里头不化呀，再上锅温温让它开就行了。

李冠杰：这条在《康平本》里是顶格的条文。

其中既有嵌注内容，又有为嵌注加的旁注，有点乱。但正因为有

了这些注解内容，跟《宋本》条文就出现一些不同的地方。嵌注的前几个字“此本柴胡”，《宋本》里是“此本柴胡证”，这个应该是对的，《康平本》里丢了个字。《宋本》里“下之已不得利”，在《康平本》里是“下之而不得利”，这个“已”肯定是错的。再者，旁注所加的位置和《康平本》有所出入，这个问题倒不是很大。

下边解读一下：

“伤寒十三日不解”。意思是说表证已经多日了，就是暗含疾病已经发展为半表半里的趋势。

“胸胁满而呕”。这个是典型的少阳病症状的反应，咱们都很熟悉了。

“日晡所发潮热”。这个“日晡所”是一个中医的术语，指的是下午三点到五点这段时间，“日晡”指的是时间，“所”在这儿是指左右、大约的意思。就这三个字把事情说得清清楚楚的，还表达得非常准确。“潮热”要按《辞海》上解释，指的是发热如潮有定时，定时发烧。但是这条里的“潮热”，胡希恕有一个解释：其热如潮，热势很重，来势汹涌。客观地来看，这条就是说：患者每天下午的三点到五点左右的时间出现了较为严重的发热症状。特别是“日晡所”的这个时候发潮热，在经方里面是一种典型的阳明里热的反应，也是比较典型的。但是，结合临床实践看，柴胡加芒硝汤证不是所有的病人都有“日晡所发潮热”，有的甚至没有发热这个症状。这个条文中实际是把它当一个主证列出来的，因为这个症状具有特征性，有明显的时间性。但是不是所有的病人都有这个症状，在临床中或许有些人出现定时发热，也有些人出现“日晡所”发高热，也有的没有发热的症状，这都有可能的。所以我们对一个孤立的症状要客观的理解，不是一个死的。那么，我们在理解不同的解释，实际上各有各的道理，都是指的一种情况，要确定是不是这个方证还得有别的症状做依据。这个条文里有吧，前面还有柴胡证的嘛！

“已而微利”，就是说潮热之后又出现轻度的下利，这个下利应该是热利而不是寒利。

下边是嵌注内容，内容篇幅还是比较长，咱们大致地看一下它的意思，再整体看一下这个条文。嵌注的大致意思就是说：本来是柴胡证，以大柴胡汤下之，不应该出现下利的情况，现在反倒出现了微利，这应该是其他的医者使用了巴豆剂之类的丸剂造成的热性下利。潮热说明就是里实。

这个地方有什么根据说是大柴胡汤呢？其一，条文里有说“大柴胡汤，下之则愈”；其二，本来就是一个柴胡证，为什么“下之而不得利”呢？这里边只有一种情况，大柴胡汤是治疗有柴胡证的泻下剂。如果有柴胡证，使用大柴胡汤不应该出现下利，这个地方反倒是出现下利了，说明用的不是大柴胡汤，就这个意思。但是，“下之”这个地方，要不然你会理解成用的是其他的泻下药，要用其他的泻下药，“不得利”反倒是不可理解了。这应该是指的是大柴胡汤。

这一段注解，是嵌注的作者的临床经验所得，临床中也不排除有这类的因素存在。但是，原文绝对没有这个意思。如果把嵌注内容抠了去，原文的意思很明白。原文的意思是：凡是这种“伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利”的情况，就可以先用小柴胡汤，然后再用柴胡加芒硝汤治疗。

“先宜服小柴胡汤以解外”。这是由于患者病程比较长，应该有虚的情况，再加上这个条文里面论述的，方证里有明显的柴胡证，根据这个先用小柴胡汤来治疗。跟前一条有相似，就是先用小柴胡汤减一减半表半里的证，然后再用柴胡加芒硝汤来治疗里实热证。但是，连着两条都出现这种情况，我们可以感悟到另外一个事：当虚实错杂的时候，尽管都是半表半里的证，也应该先治虚证。一旦有了虚证，虚证比实证要重要，要先治虚证。这也验证了那个“下不厌迟”，都是一样道理，符合人体疾病的规律。

柴胡加芒硝汤证的病理：属于阳性半表半里证合并里实热证。

下面做个小结：患伤寒已有十三日，不解，症状表现为胸胁满而呕、日晡所发潮热，然后出现微利，应该先以小柴胡汤治疗少阳病，然后再以柴胡加芒硝汤治疗。

这个小结就把嵌注那一块内容去掉了，实际上那一块是注解的，是对原文的一个补充说明，它不应该算原文里的一部分，咱们做个参考吧。

下边是方解。柴胡加芒硝汤实际上就是小柴胡汤原方，取了小柴胡汤量的三分之一，也就是小柴胡汤的一次的服用量（小柴胡汤最终煮取三升，分三次服，一次就服一升），实际上就取了三分之一，等于取了一升的量，然后加上了二两芒硝。芒硝的量相对来说就加得挺大的，分成两次喝，这是两次的服用量。这个芒硝是一个寒性的去热通便的药物，它去实的力量大于大黄，去热的力量又大于石膏。所以，这个方剂治疗的就是在小柴胡汤证基础上，同时又伴有芒硝证的一种情况。另外，凡使用芒硝的方子，都需要在药液煎好之后再加入芒硝，另外再稍微炖一炖，让它融化一下。

在《宋本》里，这个方剂的方后注解有林亿他们加的一些按语，大家看一看吧，这个按语没有太大意义，说的那些另外加的药，也很少有见这么用的。

下面是这个方剂的方证，比较简单了，这个方剂临床中用的机会少一些，医案也非常少。症状舌象也比较少。简单地跟大家一说：

症状：胸胁满或者痞硬、大便硬或者下利、往来寒热、日晡所潮热、呕吐或者腹痛拒按，口苦、口干、目眩、腹满。

舌质：主要就是红舌。

舌苔：或厚或者燥。

脉象：弦数沉微。

现代疾病：感冒、急性胆囊炎、急性胰腺炎、胃溃疡性急性穿孔、

急性胃炎、慢性胃炎、流行性腮腺炎、扁桃体炎、夜盲症（这个在其他方剂的现代应用里出现的不多，也是供个参考吧）。

伤寒十三日、不解、时谵语者、过经·以有热也、当以汤下之、①（105）

注：《宋本》此条文如下：

伤寒十三日，过经谵语者，以有热也，当以汤下之。

若小便利者、大便当硬、而反下利、脉调和者、知医以丸药下之、非其治也、若自下利者，脉当微厥、今反和者、此为内实也、调胃承气汤主之、（105）

胡希恕：这里的丸药就指着巴豆剂了。不但少阳阳明并病，吃那种丸药不行，真正的里实证吃那种丸药也不行，那个是下寒的。“伤寒十三日，过经谵语者”，已经传入于里叫过经，发谵语了，发谵语了就是里头有热了，以有热也，就是胃中有热，热结于里就发谵语嘛，胃不和。“当以汤下之”，应该用承气汤就对了。“若小便利者，大便当硬”，那么看这个病人现在呀小便自利，小便自利就是小便多，小便多呢这个水份从前阴夺去了，这个大便当硬，大便应该干。“而反下利”，这个病人这个挺奇怪，他反倒下利，这值得研究了，就是我方才讲那个，阳明病初起的阶段，大便不干的时候，热越来越亢盛，人的体液越来越丧失，一方面汗出，一方面小便数，所以他辨证为阳明病。那么这个呢，谵语说明是胃有热，而且小便也多，大便应该干才对，而反下利，看看他脉吧，“脉调和者，知医以丸药下之，非其治也”，这个脉不会调和的，后面讲三阴篇里也有，如果真正的阴寒下利，谵语是相当危险的病，那个谵语不是只是说胡话了，属于躁扰不安，那是阴阳绝离的迹象了，病要那种情况脉一定微细欲绝的，微

细而且四肢厥冷。那么现在这个人脉调和，所以不是阴寒自下利，这是大夫给吃错药造成的结果，里头并没有虚寒，所以脉调和。下利还脉调和，说明不是虚寒的自下利。那么现在这个谗语，脉调和，说明还是实，不是虚寒的问题，“调胃承气汤主之”，这个还得给吃承气汤，他只是谗语，胃气不和而已，吃调胃承气汤就行了，他没有大实大满大痛的那种情况，所以不要吃大承气汤了。

那么这个接着上面讲的，所以这个丸药，是非法的治疗，所以中医用药不是光让他通大便，咱们现在大便不通了，让他通通大便，那么你灌灌肠也行啊，不是那样，得去病，他是热结于里，你非得用寒性的泻下剂不可，尤其用承气汤这个汤剂。那么里头有寒实，那可以用巴豆剂，它是温下药，所以不只是通大便为目的，那就错了。所以这个热结于里得用寒性的泻下剂，巴豆这种丸药是吃不得的。这个是接着上边，他说不但少阳阳明并病吃这个药不行，就是真正的里实，承气汤证，你吃这个药也是不行。而且这个脉上呢，如果不吃这个泻药，脉也不是调和呀，脉绝对大，阳明三日，其脉要大，而且大实有力，不会调和的。由于吃泻药了，这个脉才调和。那么虚寒下利呢，脉也不会调和的，要微绝（厥）。他既不微绝（厥），说明他不是自下利，阴寒下利，不是的。他是由于误下，误下脉还调和，所以说不是误下，脉决不会调和，是实的，实而有力的脉，大。那么“今反和者”，说明里头还是实，所以他用调胃承气汤。调胃承气汤在头前有了。

李冠杰：这一条在《康平本》里边是两段，我们就把它分开学。

第一段，“伤寒十三日，不解，时谗语者”，这有一个旁注：“过经”，“以有热也，当以汤下之”。这在《康平本》里边是一个顶格的条文。

在《宋本》里边，把“过经”这两个字篡入正文，整个条文就出现情况了。“伤寒十三日，不解”，他要把“过经”加在这个地方，

但是加在这个地方就出现问题了，“不解”怎么还能“过经”呢？伤寒虽然十三日了，但是伤寒还在，还能叫“过经”吗？但是“过经”还要加进去，怎么办呢？他把“不解”给去掉了。这样《宋本》里边就成了：“伤寒十三日过经，谵语者，以有热也，当以汤下之”。这实际上就成了胡闹了，这个条文尽管字不多，他这一改，整个就变成其他的意思了。咱们在学习的过程当中，还会再去仔细地分析一下。

解读一下：“伤寒十三日不解”，可以理解为跟 104 条是相同的病因，都是得伤寒十几天了，但是病因相同结果却不相同。这儿十几天以后出现什么情况？“时谵语者”，表证还没有解，又出现时常的神志不清，这个“谵语”就是神志不清、胡言乱语这么一个症状嘛。

“时谵语”，不是持续性的，会时不时地出现谵语的这种情况，说胡话，神智不太清了。这个在经方里边是典型的阳明里热的症状，我们要是把它具体一点叫“胃气不和”。

条文里边还特意做了一个说明，“以有热也”，就是说这是热证。这个“过经”在这个地方毫无价值，原文没有这个意思，这是强加的，是注解的作者他自己的认识。我们跟《宋本》一比较，就发现了我们刚才说的这个问题，他一旦把这两个字加进去，整个这个条文就变得有问题了。

实际上它这里边还有另一层考虑，要是用承气汤来治疗的话，它有表证，按照治疗规律，外有表证里有热是不是应该先治表证？这儿直接用调胃承气汤，因为它下边是“以汤下之”，“以汤下之”呢我们待会儿看，用调胃承气汤是不是有点不对了？大概是经过反复思考，然后把“不解”给去掉，换成“过经”，十来天不就过经了，过经以后发生阳明病了，用承气汤之类的方剂不是正好吗？整个就变得通顺了。

实际上原文在这个地方说的，恰恰是一种特殊的情况，就是可以用调胃承气汤来治疗。这是有其他条文可以佐证的。

“当以汤下之”，我们可以从两个方面来理解：单纯地从字面上来理解呢，可以这么理解，提示读者可以从三个承气汤当中，根据具体情况，这刚说了个“谗语”，要有大便不通，可以用小承气汤，如果结得再厉害，再有热，热得再厉害的话，用大承气汤也没有问题，给你一个选择的余地。这是一种理解。

另外一种理解，很可能这个条文就是一个残缺的条文，本身就不完全。经方的书籍里面这一类的论述非常少，如果说“宜”用什么汤，或者说“与”什么汤，这都好理解。但是，就这么含含糊糊地说了一个“汤”字，不像这本书里面作者严谨的风格。所以说有可能这个条文是个不全的条文。

这个地方应该用调胃承气汤。何以见得呢？咱们看一看两个条文。

第123条是这样论述的：这里也有“过经”，也是一个旁注的这种，“太阳病过经十余日，心中愠愠欲吐而胸中痛，大便反溏，腹微满，郁郁微烦，先此时自极吐下者，与调胃承气汤”。这个是经过下以后，也是太阳病十多天以后。

第248条：“太阳病三日，发汗不解，蒸蒸发热者属胃也，调胃承气汤主之”。

看上边这两条，一个是患太阳病十几天，也没说太阳病好没好；另一个患了太阳病只有三天的时间。这两条都没说这个表解没解？都是用的调胃承气汤治疗。

今天学习的这个条文，也是属于这一类情况。就说表证还存在，又有了里实热证，是调胃承气汤证。像这种情况下，再参照其他两条，用调胃承气汤是可以的，不一定非得先解表。经方的法都是活法，不是机械的。

最后一点咱们也不能忘了，这个条文原本是不是这个样子，还很难说。咱们只能根据现有的这些字面资料做这样的理解。

总地说，学习这一类的条文，重点咱要理解它的精神。这个条文重点咱们应该理解什么？如果太阳病多日不解，有发展为阳明病的可能性，这个就行了，理解到这儿就行了。

下边做个小结：伤寒十三日不得愈，而表现为时有谵语的，是发生了阳明里热证，应该用调胃承气汤类方剂下之。

再往下是这个条文的第二部分。《宋本》里面把这两条合在一块儿了。也就是第 105 条的第二部分。

原文是这样的：“若小便利者，大便当硬，而反下利，脉调和者，知医以丸药下之，非其治也。若自下利者，脉当微厥，今反和者，此为内实也，调胃承气汤主之”。这一条在《康平本》里边是降一字格排版的条文。应该说不是出自张仲景之手。

从这个条文的内容看，明显这一段条文是这个作者根据自己的临床经验所得，对上边那个条文做的一个补充说明。这样从另一个侧面印证了一个问题，上一条条文很可能存在内容不全的情况。如果内容很全，也就没有必要再作这么一大段文字，作这么繁琐的说明了。

咱们也理解一下：“若小便利者，大便当硬”，一般情况下，如果有里热就会出现小便频数小便利，这个里热啊，就是人体的机能偏亢奋，人体整个周转就快，代谢也快，就容易出现小便频数。小便频数再加上里热，水分排出的多，再加上出点汗，常常会大便变硬。但是眼下的这个病人反倒是“反下利”，可要是诊脉呢，他的脉是调和的，说明脉象和症状不相吻合，其中必有原因。下边说了，因此就知道是别的医生以丸药下之，用了其他的泻下的药，这不是正确的治疗方法。

如果不是吃了泻下的药，是自下利的一种的话，应该有“微厥”的情况。“脉微厥”，大家在解读的时候，应该是厥逆的这种症状，“微厥”不能来形容这个脉的。因腹内偏寒，胃肠功能偏弱出现这种下利，应该有“微厥”，微微厥逆的这种情况。但是现在反而脉是调

和的，像这种情况，就是内实的情况。

这个条文包括其他条文里边，有多处说到“丸药”，这个“丸药”其实《金匱要略》杂方杂疗方剂第 23 里边有一个三物备急丸，这个三物备急丸的药物组成是：大黄、干姜、巴豆，这么三味药。大家看大黄、干姜、巴豆三味药，肯定是一个热性的泻下剂。别看大黄，大黄本身寒性，比不过干姜和巴豆这两味的热性，所以说这个方剂总体还是一个偏热的方剂，而且泻下的力量很强，既有大黄又有巴豆。这个方剂叫三物备急丸，就说医者手里要经常备着的这种药，它可以治好多病，恐怕这个书里面多处提到的这个“丸药”，就是这一类的方剂。

下面我们对这一条作个小结，整个这一段实际上是论述了上一条的原文的情况，后来在《宋本》里面不是合成一条了么。这儿就应该接着那儿说：上条文所论述的情况，如果小便利者，其大便就应该偏硬，但是呢，有的患者反而表现为下利，然而脉却是调和的，这说明他医以丸药下之，属于非法治疗。另一方面，如果患者是属于寒性的自下利的话，应该有微厥的这种症状反应，但是，现在表现为脉调和，所以可以断定其为热实，这个里实热性下利，为调胃承气汤主治之证。

大阳病不解、热结膀胱、其人如狂、血自下者愈·血自下^①、其外不解者、尚未可攻、当先解其外、外解已，但小腹^②急结者，乃可攻之、宜桃核承气汤、（106）

注：

1. “其人如狂、血自下者愈·血自下、”《宋本》作“其人如狂，血自下，下者愈”。
2. “小腹”《宋本》作“少腹”。

桃仁五十个去皮尖 大黄四两 桂枝二两去皮 甘草二两炙
芒硝二两

右五味、以水七升、煮取二升半、去滓、内芒硝、更上火、煮沸、下火、先食温服五合、日三服、（注）当微利。

胡希恕：太阳病在这个阶段上，不好，就是不愈、不解，那个时候，一般说传里了，这个病有表传到半表半里到里，它就无所传了，一般是传里而发生阳明病的，但是也有热结膀胱这个部位的瘀血证，热结膀胱不是热结到膀胱里头了，而是部位，古人说关元、膀胱，冷结关元等，它只是部位说的，这个瘀血证常在少腹这个地方，因为人它是一个站立的液体的东西都向下尤其咱们现在说这个瘀血，那西医所说血栓这一类的，这一类的东西最常结在腹底，所以这个腹底盆腔这个地方，你看这个结构生理缺陷就有，静脉网血丝就那一点，当然女人指子宫了，男人也就指那个地方，也就是说膀胱与大肠夹的那那个地方，所以，打架小肚子不是全是血，为什么呢？就是胆内出血那个地方的静脉网呀，血液相当的多，因为血性就下，那个地方老存血，由于血液常在那个地方，所以热结膀胱呀！不是膀胱里面有，这个病呀，不是那个事，咱们也说这个东西，病太阳之腑，这是错的，膀胱一点都没病，哪里是那个事呀，太阳之腑有病了简直就是瞎胡扯，其人如狂，就是这个有瘀血证呀！与这个脑系上大有关系，这个我们在临床上，我也曾经用这个法治很多，所以精神病呀！它常常都是有瘀血造成的。瘀血他这个东西，随着血液循环呀，这里头有这个，古人管瘀血叫恶血，晦恶之气呀他最容易冲击大脑了，所以其人如狂，甚者发狂。真正的精神病有瘀血，用这个方子也较好使也很多，血自下，下者愈，也有这样的，有了瘀血他自己就下，如果瘀血下去，这个病也必好。如果血不是下，虽下而也没完全下，下得不够，这个病也不能好的。那个也得用药下，用药下总的来说桃核承气汤，可是一样，它讲的是表证呀！太阳病呀，其外不解者，尚未可攻，它和阳明病一样，阳明病也是其外不解尚未可攻，这个它不在胃在少腹，那么如果有外证呢，你先解外，那么解外就用桂枝汤了，如果有麻黄汤证

你可以用麻黄汤，没问题。外解已，没有表证了，但少腹急结者，其人如狂，而少腹的地方又急，急就方才讲那个急，就这个地方觉得撑的慌，为急，我们常讲的心下急，一样，同时也结，拿手按着有抵抗感，乃可攻之，这个时候只是少腹这个地方有毛病，可以用桃核承气汤。

这个方子是调胃承气汤，还是攻里呀！里有热加上桂枝、桃仁，这个桃仁这个药是祛瘀血相当有力量的药，我们最常用了，因为桂枝，又其人如狂了，他这个晦恶之气往上冲，这个桂枝，降冲气的。不然的话脑袋好不了他以调胃承气汤加上治上冲的桂枝祛瘀血的桃仁所以这个方子，他在调胃承气汤的基础上，我们在临床上应用呢，有承气汤证，就是调胃承气汤证，气上冲内有瘀血其人如狂者，回到少腹急结，这都是调胃承气汤的证候，就是调胃承气汤证、气上冲，少腹急结，其人如狂者，就是这样子就可以用了，这个其人如狂呀，在这个瘀血证里头，尤其是急性发作的最多，那么我们再讨论讨论这个病是不是这个瘀血就是在这个太阳病的这个阶段上呢？造成的呢，不一定，这个瘀血呀都是在人体里面有潜伏，这个多种原因的。但是热病的时候也能够使之有，里头有瘀血，就是内出血了，伤寒论有内出血的情景，但是呢，不能用桃核承气汤，当时这个出血不是瘀血，他不如狂，他只是便血，肠伤寒有便血的咱们用桃花汤那种方子，后头在少阴病里有的用桃核承气汤的机会没有，这个瘀血呀都是人们内平时有所潜伏，那么在这个伤寒也好，一般外感也好，也能够诱发瘀血瘀热的发作，所以这个古人呢，说这个热结膀胱，尤其这个书也有这个话说太阳随经瘀热在里，这些话是古人一种测度的说法也都靠不住了，是不是这个瘀血治疗不对？那是对的，这种规律就是其人如狂，少腹急结，你用桃核承气汤都会用都对，这种规律方法是毫没问题的，古人从经验里得出来的。是不是由于太阳随经瘀热在膀胱啊？这值得研究，有的是不得太阳病，瘀血证也发作，也有这种情况，那你怎么

说呀？不是，现在咱们居然把这段他说是太阳腑证，太阳腑证就是膀胱病呀，你看看这个是膀胱病吗？与膀胱一点没关系呀，不是膀胱病。

李冠杰：《康平本》在“其人如狂”后，“血自下者愈”，是旁注内容，《宋本》将旁注内容篡入正文是这样的，“其人如狂，血自下，下者愈”，非常明显《宋本》为了使句子通顺，所做的修改，这个几乎毫无疑问。另外条文当中的“小腹”，在《宋本》是“少腹”，这两个字相通的，没有质的区别。

下边我们解读一下：

“太阳病不解”，本来就是太阳病，为什么太阳病不解啊？是因为治过，或者失治，或者误治，太阳病还没有解除。之所以不解是在提示下边的疾病，可能由太阳病不解发展而来，有这方面的意思。

那么“热结膀胱”，这是古人对桃核承气汤证做的一个病理解释。如果我们现在理解的话，就应该理解成“热结于少腹”。这个“膀胱”说得不太确切，因为这个方证绝无膀胱的症状，没有膀胱的病变，所以这个“热结膀胱”指的就是少腹的意思。但是这个地方使后世理解经方理论出现了很多偏差。这说了膀胱，前边说“太阳病不解”，差不多是除了胡希恕以外吧，其他的注家都把它注成“随经入腑”。就是说外邪随经入腑，从足太阳膀胱经进入膀胱了。实际上这种说法是不对的，这不符合经方理论。

“其人如狂”，这个“狂”是指的精神躁狂失常的病症。那么“其人如狂”的意思，就是说患者发生了如同狂躁失常的这种精神病。病人为什么会出现精神方面的一些问题呢？不外乎两个方面：其一就是里热严重，我们从治疗方剂当中可以明显地看出来，方剂当中有一个完整的调胃承气汤方，所以这儿的“其人如狂”就包括了调胃承气汤中的胃气不和谵语的这个因素存在，也就是说里热严重，这是一个因素；第二个因素是瘀血，坏死以后的血液成分不参加血液循环，它停留在某一个地方，就会发生变质，变了质以后会产生一些氨，这些氨

随着新鲜血液流遍全身，影响最大的就是人精神方面的问题。我们从经方里边也能看出来，凡是有瘀血证“轻则喜忘、重则其人如狂”，说胡话这一类的精神方面的症状。你看古人总结的这个，就是从临床中来的嘛，也非常贴切。

旁注我们先放一放，按着正文往下学。“血自下”，就是指的便血，或者妇科有下血的症状。这个症状并不是特别得多见，不一定。从临床统计资料来看，有下血，甚至衄血这一类的情况，但是出现的几率并不高。那么在这个条文里边把它强调得这么高是什么意思啊？重在强调这个方证有血证的存在，重在强调有血证。

下边“其外不解者、尚未可攻、当先解其外”，是论述的治疗方法，或者叫治疗原则。但是这儿呢，有一个问题，从药物的组成上来说，祛瘀血的药就一味桃仁，恐怕里热是一个主要矛盾。里热证和表证同时存在的时候，治疗原则就是先治表证，后治里热，这个地方就符合这个原则；但是如果是纯血证，那就例外了，当血证和表证同时存在，治疗上先下血，因为瘀血是主要矛盾。这是临床当中我们应当知道的常识。这儿告诉我们如果有桃核承气汤证，同时又有表证，应该先解表。

但是，桃核承气汤证是一种挺严重的精神病，又有发热，有点恶寒，他有表证，在这种情况下，解表的方法一定要辨证非常准确，而且服一次即得。为什么？人疯着呢。大家想想这是一个很急迫的病，甚至你都没有机会去辨别他有没有表证。但是有这么一个原则，如果临床当中发现真有表证的话，你可以剂量稍微大一点，辨证准确一点，一付即得。就可以用这个方剂治疗了。

“外解已，但小腹急结者，乃可攻之”，服了解表药，表证的症状消失了，然后再针对“其人如狂”、“小腹急结”这样的情况治疗。方剂就是桃核承气汤。这个“小腹急结”，按照标准的解释：少腹部或痛或胀，急迫、拘急，痛苦不可名状的这么一种病。实际上我们在

临床当中，做个腹诊就比较明确了，你去按按他的小肚子，肯定会拒按的。这个时候腹诊就显得比较重要了。

回过头来我们再看一看旁注“血自下者愈”。意思就是“热结膀胱，其人如狂”这一类的疾病，出现下血的情况的话，就可以自愈了。大家仔细分析下，前边有“血自下”，原文里边绝无可以自愈的意思，根本就没有这个意思。我们客观地说，既然作者往里边加这样的旁注，恐怕他在临床当中可能有过这一类的经验，所以我们还是存疑，但是跟这个条文的意思绝对相背的。而且，在临床统计资料里边有月经量多，尿血，衄血，黑便，有这样的症状存在，但是，病还没好啊，所以还要用桃核承气汤治。那怎么叫“血自下者愈”呢？所以说这个旁注是值得分析研究的，咱们存疑吧。

学习这个条文，重点上应该弄通这几个基本问题：第一，桃核承气汤证可能由表证发展而来。其二，当确认这个方证同时又伴有表证的时候，应该先解表，然后再治桃核承气汤证。第三，按着经方理论的常识，如果没有经过表证阶段，直接发生这个方证，用这个方剂一样治疗。第四，如果我们结合临床的话，这个条文里边所论述的这些症状，都是这个方证一些典型的症状，实际上在临床当中，病人还会有若干的里实热或者瘀血证的一些脉象，舌象。

桃核承气汤证的病理：阳性里实热证合并瘀血证。

下边我们做个小结：本来是太阳病，没有解除，患者又发生了热与血结于少腹的病证，病人表现为如狂，血自下，如果此时表证仍未愈的话，不能先治疗热结的病证，应该先根据症状的反应以适当的方剂来解除表证，当表证解除后，患者仅表现为少腹急结等症状的，宜用桃核承气汤治疗。

下边我们再看看方解，桃核承气汤有五味药组成，有桃仁、大黄、桂枝、甘草、芒硝。实际上就是调胃承气汤加桂枝和桃仁。调胃承气汤去热的力量大于去实的力量，因为里热而造成的胡言乱语、谵语的

症状，就是调胃承气汤治疗范畴。桃仁是寒热倾向不很明显的一味祛瘀血的药，有破血行淤，润燥滑肠的功能。

我在上学的时候，文革后期那个年代，有一个事对我印象挺深，有一本很旧的小册子上说过一个事儿。有一个还没有结婚的姑娘，得了神经病了，还是跟感情有关的相思病，精神失控没有人能管得了她，疯疯癫癫的。有一次自己爬到一颗很大的桃树上去了，恰恰是桃树开花季节，她就没命地摘桃花吃，开始人没管她，她总在吃，人们怕糟蹋树，就把她弄下来了，后来就大睡了一场，病好了。这个事的可信度我们不敢说，但是，大家想想跟这里有相通的地方，桃花和桃仁都是一个植物上的，恐怕性味上有相似的地方。

这个方后注里边有两点咱们需要注意下，一个是芒硝需要分冲，药液熬好了以后把芒硝再加进去，稍微再加加热；另外要求饭前服，有些下瘀血的药有这样的要求，桂枝茯苓丸也是这样的要求。

下边再看一看方证：

症状：小腹疼痛、便秘、神昏谵语如狂、小腹硬痛拒按、发热、小便短赤、心烦、口渴、月经量多有块色暗、面色晦暗、腰疼痛、血尿、小便难、面红目赤、头晕、头疼、胸闷痛、少寐、口燥咽干、少食、呕吐、步履困难、心悸、下肢冷麻、衄血、肩背痛、便黑。

舌质：红舌、有瘀点或瘀斑、舌紫暗、酱舌、舌淡、舌黑、舌青、舌胖、裂纹舌。从舌象也能看出来，这么典型的瘀血证，这么热的病，还有淡舌的情况。所以，任何一个证都不能作为确定方剂唯一的依据。

舌苔：黄苔、白苔、腻苔、苔干燥、薄苔、厚苔、灰苔、黑苔、少苔、有芒刺。

脉象：沉脉、数脉、弦脉、涩脉、滑脉（大家看，一个是涩脉，一个是滑脉，这恰恰是两个相反地脉象，有瘀血有可能呈现涩脉，有热则可能出现滑脉）、细脉、实脉、紧脉，还有洪脉、大脉、濡脉、迟脉、伏脉、缓脉、弱脉、浮脉、结脉、散脉、兼脉。

那么这些数据啊，大家都不能当做耳旁风听完就得，大家得动脑子想，这是临床资料，这就是临床实践，所有的理论都得跟它接轨。如果说接轨，桃核承气汤证出现了这么多的脉象，我们应该怎么来对待这个脉象？脉象跟其他的证是一样的，脉象有自己的客观性，不受病人主诉的影响，这是医者的一个感觉，所以具有客观性。但是，没有一个某个方证里边必见什么脉象，甚至哪一种脉象是个绝对多数，你都很难把它确定下来。所以说呢，客观地对待脉象的话，脉象和其他的证一样，都是我们用方遣药的一个依据，都是依据之一，但是也不能作为唯一的依据，都要四诊合参。

桃核承气汤的现代应用：

急性肠梗阻、急性坏死性结肠炎、急性坏死性肠炎、急性肠炎、直肠溃疡、胃及十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎、痢疾、暴发性痢疾、麻痹性肠梗阻、胃柿石、机械性肠梗阻、消化性溃疡、急慢性肝炎、肝昏迷、急慢性胆囊炎、胰腺炎、急性胰腺炎、肠道寄生虫病、高血压、动脉硬化、精神分裂症、脑挫伤、反应性精神病、流行性出血热、脑血管意外、脑震荡后遗症、多发性脑梗塞、癫痫、瘰病、反应性精神病、三叉神经痛、月经不调、闭经、子宫内膜炎、子宫肌瘤、输卵管结核、不孕症、痛经、人工流产、胎盘残留、子宫肌瘤、盆腔炎、产后阴道血肿、卵巢囊肿伴盆腔静脉瘀血综合征、子宫脱垂、附件炎、更年期综合征、习惯性流产、产后感染、胎死腹中、糖尿病、神经衰弱、脑膜炎、森林脑炎、胸腰椎压缩性骨折、增生性脊椎炎、肺心病、心肌梗死、肺炎、尿道炎、慢性肾炎、急性肾小球肾炎、泌尿系统结石、前列腺炎、慢性肾功能不全、肾炎尿毒症、特发性尿血、慢性肾盂肾炎、慢性肾功能衰竭、尿潴留、运动性血红蛋白尿、急性间歇性卟淋病、尿路结石、内痔嵌顿、膀胱肿瘤、眼外伤、结膜炎、麦粒肿、视网膜炎、角膜炎、白内障、湿疹、荨麻疹、冻伤、血小板减少性紫癜、过敏性紫癜、骨质增生、关节炎、外伤、风湿病、结核。

前两天我跟大家说的那个神经病的病人，十来天呢，她丈夫每天都给我打一个电话，她现在就跟好人没有什么区别，但是药还在吃。稍微有一点口苦，出现了嗜睡的症状，这样她就恢复得快了。她现在手头上给她有三种药，一种是大柴胡汤合上桃核承气汤，因为她有口苦，有明显的柴胡证，她最初是吃桃核承气汤好了的，后来呢，她能来诊的时候，根据她的脉象，口苦，往来寒热的情况，就给她大柴胡汤，因为她有里实的情况，就给她合上桃核承气汤，吃了以后就很快就接近常人了。因为她体质比较弱，逐渐地实证不那么明显了，我又给她柴胡加龙骨牡蛎汤，这个时候柴胡加龙骨牡蛎汤和大柴胡汤合桃核承气汤，是不断地在变化比例，根据她那个情况不断地在变化。第三个方剂是什么呢？她有肌肉跳动，有点像帕金森综合症一样，那个抖啊，现在她神经病好了以后，她那个病又发作了，我就给她防己茯苓汤合上当归芍药散，她既有水又有贫血的情况，实际上她现在既有血证的实证，又有血证的虚证。那脸色黄黄的，你扒开下眼睑看看，那里边都几乎看不到血丝。这样呢，她的肌肉跳动的症状也基本上就痊愈了吧，基本上就是所有的症状差不多快好了。还有一个患脑瘤的，他还是转移性脑瘤，就是癌证。他那天也是热得厉害，就喘出气来都特热，再加上他大便也不通，我给他也是桃核承气汤。他是单纯的桃核承气汤，神经病好了，那个病也稳定了，大便也通了，身上也轻松多了，头也基本不痛了。

那么通过桃核承气汤这个方证，我们来看看，在单个的方证之上，还应该有一个什么样的辨证体系？这个辨证体系来龙去脉是怎么回事？这个桃核承气汤证，有里证、有实证、有热证、有阳性证，在六经，八纲里边都有相应的内容。但是瘀血证，这两个辨证体系里边都没有。但是这个血证呢，却是一个非常重要的辨证因素，如果不包括的话，这个辨证体系应该是不完整的。我们从桃核承气汤应该能看出这么一个问题出来。

再具体的分析一下，先看看六经辨证。经方理论里边的这个所谓的六经辨证，实际上是后世医家命名的。咱们看《康平本》就看得非常清楚了，它就是辨太阳病，辨阳明病，辨少阳病，人就是六大类疾病。它的实质就是将常见疾病的症状反应，按照这些症状之间反应内在的一些规律，划分成了三阴三阳这么六大类的疾病类型。这就是所谓六经辨证的实质，人家是这个东西。大家看啊，经方的书里边，条文里边有很多提到寒热、虚实，包括血证、水证都提到过。那么这说明什么？说明这个三阴三阳就是经方辨证体系里边的一个基础部分，应该还是比较重要的，这是肯定的，因为它作为题目提出来了。它是一个基础部分，但是它不是全部，它不能涵盖寒热，虚实，水证，血证。里边实际上不包括，人家也没想让它包括，条文里边都有了。实际上古人是把症状分为六大类的疾病，把六大类疾病当作主线，来论述经方理论整个辨证体系，人家是这么一种情况。实际上就是说当作提纲，或者当作框架来论述的。其他的辨证要素呢，都隐含在条文里头了。如果能这么理解的话，你就会发现，实际上六经辨证，就是后世医家在对经方理论还没有完全弄懂的情况下，做的一个机械的片面的总结。再加上王叔和把辨太阳病一下又弄成脉证并治了，就弄得更叫人难以见它的原意了。人家原书压根就没有这意思。那么我们进一步地再去分析，回到胡老的那个基本观点上，从这个角度看经方里边的三阴三阳的话，就跟《内经》里边的三阴三阳形成了鲜明的对照，它对的不是一体的东西。《内经》是用三阴三阳的方法对人体的经络进行分类，而《伤寒》同样也是用这个方法，但是分类的对象却是人体患病以后，表现出来的症状反应。所以两者方法相同，研究的对象不同，这一点非常重要。

下面咱们再看看八纲辨证，实际是后世医家在长期的临床实践和理论研究的基础上，总结出来的一个辨证体系。这里包括了表里，就等于有了半表半里了，同时也有阴阳、寒热、虚实这样的疾病性质的

辨证要素。实际上说透了，还是针对着六经辨证，六经里边不包括这套东西，那么经过总结，看着是起一个补充。实际上大家在相当的一段时间，一个范围里边，就认为这是高于六经辨证的，特别是时方的医家特别推崇它。但是，八纲辨证里边也不能涵盖水证、血证这样的辨证要素，也不是一个完整的辨证体系。把这两个主要的辨证体系具体地分析一下，实际上都不是完整的，都存在着相当大的一部分缺陷。比如水证：像五苓散证，真武汤证，猪苓汤证，泽泻汤证、猪苓散证这一类的方证，真武汤证还有一个它是个阴证。猪苓汤、五苓散、猪苓散、泽泻汤就是纯水证，你别的靠不上。透过这些方证，你再去看看那两个辨证体系，都成问题了，都不够全。还有血证，比如胶艾汤，桂枝茯苓丸这一类的方证，在六经辨证也好八纲辨证也好，这里边都很难把它概括进去。还有气证，这个气证就是指的那种患病以后，有明显的气体滞留或者气体上逆的这一类的，比如旋覆代赭汤证，橘枳姜汤证，厚朴生姜半夏甘草人参汤证，这一类的都是有气证，也确实确实有它自己的一个特征。在这两个辨证体系里边都没有。这个对经方辨证体系来说，这是很重要的一个事儿。

所以我们从原则上说，一个辨证体系首先对这个理论体系及以内的所有的方证，应该有全面的概括和科学分类。它得满足这个基本要求。而且它的辨证要素包括绝大多数的方证的内容。更重要的一点，这个辨证体系还要能跟临床实践相吻合。而且反映的也是疾病的本质。

在这一方面探索的人很多，真正有突破的人不多。胡老在这方面做了大量的探索，后来他专门写过一篇论文《论食、水、瘀血致病》。这是胡老生前的手稿了，他收集了很多方证条文。证明宿食、停饮和瘀血，也是致病的非常重要的因素。实际上，胡老就已经研究得很深入了，但是胡老不想自己另外搞一个辨证体系，他连书都不出，他比较低调，也比较严谨。到了晚年，他自己也觉得有一些东西应该留下

来了，不然确实在这方面有些损失。胡老这篇文章不能小看。他实际上就是等于在说六经、八纲辨证都不是完整的，要完整的话，这一块就没有必要，实际上就是这个意思。

我们如果客观地来看的话，并不是我们现在临床辨证当中和我们中医的理论里边，还有多少辨证要素没有总结出来，不是。相反的，倒是总结出来的辨证内容过多，过杂，以至于鱼龙混杂。没有形成一套真正的完整的科学的辨证体系。而整个的辨证体系把这些东西都蕴含在《伤寒论》《金匱要略》里边。人家其实都有啊。像血证，水证，包括气证，其实都有的，只是古人没有明确出来。从这一点上八纲还是个突破，把阴阳、寒热、虚实明确出来了。

我们再回过头来看看，看看这个经方理论涉及到的辨证要素是不是可以这么归纳总结一下。经方的辨证要素：有表证、有里证、有半表半里证、有水证、有血证、有气证；有阴证、有阳证、有寒证、有热证，有虚证、有实证。关键的问题是要把他们系统化，把他们内在的规律和关系要明确出来，只有这样才能形成一个体系。那么我们具体地看一下，这些辨证要素，带有类同的性质，用来界定疾病的属性：比如表证对应的是麻黄汤、桂枝汤这一类的方剂；里证对应的是承气汤、理中汤、白虎汤这一类的方剂；半表半里证对应的就是柴胡剂这类的；水证对应的是五苓散、真武汤、泽泻汤之类的；血证对应的是胶艾汤，当归芍药散，桂枝茯苓丸；气证对应的是橘枳姜汤，厚朴半夏生姜人参汤。它都有实实在在的方证对应，而且这些方证各自都有同一属性，我们把这些带有属性的辨证要素，称作疾病的类型。但是有了疾病的类型之后，还要进一步界定疾病性质，这样才能确诊疾病。而阴阳、寒热、虚实这些要素就是来界定上述各种类型疾病发生了什么性质的病变。

比如麻黄汤证，就是表证当中阳性的实证；而桂枝汤证就是表证当中阳性的虚证；桂枝加附子汤就是表证当中阴性的虚证等等。

这样，我们就把这些辨证要点分成了两大类：一类是疾病类型，另一类是疾病性质。我们再来看一看今天学习的这个方剂，桃核承气汤的病理是什么？它的病理是阳性的里实热证合并瘀血证。有里证、有血证，里证又是阳性的里实证和里热证，瘀血证是血证里面的实证。这就是桃核承气汤证涉及到的辨证要素及辨证要素之间的关系。那么这样呢，临床当中病人所患的疾病，可能是各种各样类型的，可能是表证，可能是里证，也可能是半表半里证，可能是水证，也可能是血证。不管是哪一种类型的疾病，这种类型的疾病又可能出现各种性质的变化，可能是阳证也可能是阴证，就形成了一个非常庞大的复杂的疾病的交错关系。这一套关系，恰恰就反应了疾病的实质，这就是疾病的本质，也就是经方理论对疾病的诠释。

如果我们再进一步深入地研究的话，你还会发现这些辨证要素之间，还存在着更具体的一些关系。我在这儿说一下疾病性质的要素，这一类的要素之间存在着一个特殊的定向的从属关系。胡老曾有论述，就是“虚实无常，寒热有常”。

单纯说虚实，虚为阴，实为阳。当虚实与寒热同时存在的时候，虚实随寒热的属性而变化。比如虚证和寒证同时出现的话，虚就为阴，但是虚证和热证同时出现的话，就成了虚热证，虚热证整体就是阳性病。虚证就随着热证属阳了，本来是个阴性证但是它属阳了。

咱们再看看寒热，单纯说寒热证的时候，热证是属阳，寒证就是属阴。当寒热与阴阳同时出现的时候，那么寒热的性质也会随着阴阳的变化而变化。比如热证与阴性证同时出现的时候，热证就随着阴性证属阴性了，比如肾气丸证，肾气丸证有热证，它大量的用生地，实际上是一个虚热证。但是这个证一旦出现在阴证里面，整个肾气丸因为里面有附子，实际上是一个阴性证，临床当中凡是用肾气丸的人机能明显有沉衰的，那么这个热也随了整体，是个阴性证，这个热性也随着阴性证改变自己的属性。你看竹叶汤，竹叶汤也是，本身有表证

又有里热，但是人体机能沉衰已经陷于阴证了，整个方证也是对的一个阴性证，这个热也属阴了。

还有一个问题前面跟大家说过，恐怕有这样认识问题的，不是很多。就是表证的寒热，对疾病性质没有质的影响。比如麻黄汤证与桂枝汤证都有表热的存在，而且都没有里热；一有里热性质就变了，麻黄汤一旦有了里热，就成了麻杏石甘汤证了，或者是大青龙汤证了，那就不是这个方证了。

因为没有里热，所以治疗方剂当中几乎全是温药，没有寒性药。像理中汤、四逆汤，他们在临床当中常常表现为表寒，像四肢厥逆。但有的时候也会表现为发热，表热证。但是，这种发热对疾病的治疗毫无影响。所以体表发热，只是人体在抗御疾病过程中一种特殊的症状反应，不反映疾病的实质。所以我就用一句通俗的话说，表证无寒热。

大家可能会说，温病里边的风热感冒。风热感冒实际上是既有表证又有里热，或者是半表半里证，都这样。像舌苔黄、口干，经方里边这不是典型的里热症状吗？

我弄了这么一套东西，我叫做病理辨证，因为这些要素都是人体病理变化的总结，这就是经方的病理辨证。用不着六（经）用不着八（纲）。我弄的这一套，我为什么敢拿出来，给大家全盘托出，是因为我在临床中，用纯经方治病。不管什么病，小到感冒，大到癌症，全都是用经方来治疗，而且有效率能在百分之八九十。有了这一套辨证体系以后，临床当中感觉自己的疗效有了质的飞跃，甚至包括自己的感觉，基本杜绝用错了药的问题。只要把这一套体系掌握好了，即使辨证的功夫不太到家，也不至于出现大的医疗事故，因为方向是对的。

这是咱们借着这个条文，跟大家说一说经方的辨证体系。有一些就等于是我总结了胡老想说没说出的内容。

伤寒八九日、下之、胸满烦惊、小便不利、谵语、一身尽重、不可转侧者、柴胡加龙骨牡蛎汤主之、（注）本云柴胡汤·今加龙骨等①·（107）

注：《宋本》无“（注）本云柴胡汤·今加龙骨等”。

又方①

注：《宋本》无“又方”二字。

柴胡四两 龙骨 黄芩 生姜切 铅丹 人参 桂枝①
茯苓各一两半 半夏二合半洗 大黄二两 牡蛎一两半 大枣
六枚擘

注：《宋本》“桂枝”之后有“去皮”二字。

右十二味、以水八升、煮取四升、内大黄切如棋子、更煮一两沸、去滓、温服一升、①

注：

1. 《宋本》此处有“本云柴胡汤，今加龙骨等”十字。

胡希恕：这又一个柴胡剂，那么伤寒八九天，全是五六天之后了，言外的意思就是传入到半表半里，而为柴胡证的这么一个阶段。那么这个少阳病尤其柴胡证不能吃泻药，下之胸满烦惊，这个你得看少阳篇，少阳篇有这么一段：少阳中风，两耳无所闻，目赤，胸中满而烦者，不可吐下，吐下则悸而惊。这个少阳病在胸腹腔间，热邪在这里，你要吃吐药或者泻药啊，我刚才讲了：虚其里，里面没有病，那么这个热啊尽往里边去，不但热往里去，若里面夹着饮，这个饮也要往上攻，胃虚嘛，都往那边凑。那么这个就是由这个胸满烦惊知道以前是柴胡证。误下了，这个少阳病所以胸满，就是胸胁苦满而不去，而且烦而且惊，这个惊呀都是热攻冲头脑的一种情况。胃虚了，那么邪热

客气都往胃上面跑，所以这个水也随之上不下，小便不利，谵语，热到里头了所以说胡话了，所以胃中燥则谵语，胃气不和了，一身尽重，这个水往上，不往下走，一身都沉，而不可转侧，转侧相当困难。这就是给治坏的病，本来他是个柴胡证，吃了泻药又引邪入里，而且里饮邪热之气跑到胃这块来了。小便不利，身上停水，精神虽不是如狂也是惊恐，这都是一种精神官能症，和脑系有关系。这就是热，他往上攻，所以他用了柴胡加龙骨和牡蛎来治疗。

那么这个方子呀是小柴胡汤加的是龙骨牡蛎，铅丹，桂枝，大黄这些药，那么还是用这个柴胡剂，还是这个胸满而烦的，这个惊的用镇静药，龙骨牡蛎铅丹都是这个，龙骨牡蛎治这个精神失常呀、神经官能症用龙骨牡蛎机会最多，尤其人这个烦惊呀，胸腹跳呀，用的机会最多了，这个铅丹与龙牡一样也有镇静的作用。这个铅丹我不常用，这个铅丹是有毒的，你用这个药分量你要注意，其实不搁铅丹一样有效，我就常不搁，他由于有谵语，有热所以用大黄，那么气上冲呢就搁桂枝，那么这个就治小柴胡汤证，气上冲，有烦惊这种情况就可以用这个方子。这个方子在一般精神病里头也有用的机会。不纯粹是瘀血证，也有精神失常，用柴胡剂，柴胡剂这类的药与脑系就有关系，你看看小柴胡汤证，默默不欲饮食，这个默默就是昏昏然，所以用小柴胡加味我们对神经官能病呀，尤其加龙骨牡蛎大黄之类的药。用大柴胡汤加这个和小柴胡汤加这个都行。也看情形了，这个是小柴胡汤加这个药，这个铅丹呢能不用可以不用，用他普通开3克也毫无问题，你要大量开容易中毒的。

李冠杰：在康平本里，条文的最后有：“本云柴胡汤，今加龙骨等”这么几个字，但是宋本里没有。是丢了还是第二次整理的时候把它删掉了，推敲它没多大意义，大家知道两个版本在这个地方有一点差别就行了。还有一个值得注意的，康平本里这个方剂前边有两个字“又方”，有这两个字，而不是方剂的方名。同时，在康平本里“又

方”两字和方剂的组成，全都是用降两字格的格式排版的，这在康平本的方剂里边是比较少见的。现在我们很难确定原因，因为没有依据，和别的方子有这么一点区别，看研究吧。

下面我们解读一下。

“伤寒八九日下之”。伤寒八九日，就是病程比较长了，本身就暗含有发展成少阳病的意思。“下之”，太阳病也好，少阳病也好，下法都是误治。再加上太阳病已经这么长了，它肯定对人体的影响是比较大的。

病人出现什么反应呢？“胸满烦惊”。“胸满”是典型的少阳病的症状反应；“烦惊”是烦躁惊恐的症状，在这儿可以理解成小柴胡汤证中的“默默”和心烦证的重症，那么就不局限于半表半里证了，里边有新的因素。

前边条文对类似的情况，不是说变成这个，就是说由太阳病发展为少阳病的，都有过论述。如果少阳病又伴有里虚证的，就是小柴胡汤证；如果出现了伴有里实证的，就是大柴胡汤证；如果偏于里热证的，就是柴胡加芒硝汤证。这一条里它论述的是出现了少阳病之后，偏于精神方面的病变的一种情况。大家看，从病因上没有什么奇特的，下也好，不下也好，下也有出现里热的也有出现里实的，反正是从太阳病发展过来以后，又出现了表现为主要是精神方面的情况。

“小便不利”是体液代谢不良的一个典型的症状，说明不单是发生了少阳病，同时还有停饮的问题，这是一个比较典型的症状了。

“谵语”是里热证的一个比较典型的症状反应。但是这儿的谵语，和真正的像调胃承气汤包括桃核承气汤的那个谵语是有区别的，那一类的“其人如狂”的症状肯定也包括谵语了。这个谵语主要是精神方面的因素，那种“如狂”的成分要少一些，也不能说没有，但是少一些。

“一身尽重、不可转侧”。这儿是由两个病理因素造成的，它是

说“停饮”是一个比较主要的因素。人体停饮以后，不仅仅是肢体里面含的废水量增加，而且废水还阻碍新水的供给，一方面肢体重量增加，另一方面肢体的动力减少，就是能量不够，失养嘛，劲头也不大，所以就会感觉到肢体沉重，“一身尽重”了。另外一个因素就是神经系统状态不好，柴胡加龙骨牡蛎汤还治一些神经系统的像肢体的颤抖之类的病，不仅仅是精神方面的。所以“一身尽重”里也应该有神经系统状态不好所造成的。“不可转侧”是肢体活动不太灵便的一个症状，其实也是上边两个因素造成的，但是“不可转侧”恐怕神经方面的因素就重一些。这个方剂治疗什么呀？比如治瘫痪、癫痫、舞蹈病，这些疾病大部分都是神经系统方面出现了问题才造成的。这个条文所论述的实际上就是一个比较复杂的疾病，从方剂里也能看出来，在临床当中的表现也比条文里论述的复杂得多，条文里拣的有代表性、特征性的症状举了一些例子，在临床当中还需要举一反三，要去感悟，别碰到条文论述以外的症状就不敢确定了，那也是会影响治疗的。

这个方证的病理相对就比较复杂了。它是一个阳性病，阳性的半表半里虚热证，合并水实证和里热证、里实证还有里虚证，它实际上是虚实错杂。虚实错杂哪儿来的？它本身就包括一个小柴胡汤，小柴胡汤里有人参，甘草是去掉了，既然有人参它就有虚的这方面的因素，再加上说的病因也有这方面的问题。方剂当中又有大黄，它肯定应该有实的因素存在，大黄的特性它跟什么下什么，它跟去热的药它下热，跟去实的药它下实，跟驱寒的药在一块儿它还下寒，像那个大黄附子汤。

做一个小结：伤寒八九日的时间，反而误用泻下的方法治疗，进而患者表现为，胸满烦惊，小便不利，谵语，一身尽重不可转侧的，为柴胡加龙骨牡蛎汤主治。

这个方剂一共是十二味药组成的。那么这个方剂可以看做是小柴胡汤去甘草，加了桂枝、茯苓、龙骨、牡蛎、大黄、铅丹。其中桂枝、

茯苓、生姜这三味药还可以把它看成是茯苓甘草汤去了甘草。为什么在这儿做这么一个提醒呢？这个茯苓甘草汤，胡老把它加上龙骨牡蛎用来治疗失眠，因停饮气上冲为主要问题的失眠，效如桴鼓！确实我治过不止一例，非常好用。但是辨证得对，确实辨准了用药下去，当天就能睡个好觉。这个方剂里差不多就有了它，所以说对我们理解茯苓甘草汤有一定的帮助，它对情志方面的一些因素确实有作用。

龙骨牡蛎，在经方中主要用来治疗精神方面的一些疾病，有安神镇惊、治疗烦惊和胸腹悸动这类的作用。但是在时方里它的应用范围还要宽泛的多，包括像那个盗汗、遗精等好多病，就说失去常规的这一类的病。但是在经方里好像用得没有那么宽。这个药效，要看看药典的话，说实在的也不是解释的非常确切。我看过《本草疏证》里对牡蛎的解释比较有启发，它说牡蛎就是长在海边石头上的小嘎啦，涨潮以后它就要赶紧打开壳在海水里觅食，如果海水退潮以后要马上闭合拢，还得留一点水分保持自己的小生存环境。按现代医学的眼光来看的话，它和别的嘎啦皮没什么质的区别，但是它这种生物本身有一个很重要的特性，它要严格按潮汐的规律来做，所以治疗精神过度的亢奋，或者精神过度的低沉，都属于它的治疗范畴，这也挺有意思。这其中的机理在哪儿？恐怕在相当的一段时间里我们还没法去认识它，但是确实中药里有好多药都有这种特性。比如看龙骨在地下沉寂了上万年，它特性就是稳、沉，所以它治一些烦、惊一类的疾病。前两天有个七八岁的小孩子，有小肠疝，小肠经常会沉下来形成疝气，就用蜘蛛散去治，就是蜘蛛和桂枝两味药，他同时有停饮的情况，就给他先吃了五天的五苓散。我当时手头上没有蜘蛛，让他家人去逮，逮回来的蜘蛛非常小，但是也有作用，后来就明显的轻了，下来的次数明显的少了，后来家长一直没有再来。就吃了一次，弄了二十多个蜘蛛，很小很小的，放在一块儿一两克的样子，我炙了一炙，可能加了 15 克桂枝，量非常少了，但是还管用。大家想想蜘蛛为什么可以

治小肠疝呢？疝气就是在那个网油里面漏出来的肠子，蜘蛛它不是织网的吗？说到这儿有点可笑，但是它能治病。因为考虑蜘蛛有毒，后来也参照了一些其它的医案，也没那么可怕，结果没有任何中毒的反应。

下边看看柴胡加龙骨牡蛎汤这个方证。咱们不去读具体的数字了，先说症状。

症状：精神不安或者呆滞，失眠，多梦，胸胁满痛，心悸，便秘，头晕目眩，惊恐，抽搐，食少纳呆，头痛，月经紊乱，小便不利或者短赤，口干苦，身重难以转侧，恶心呕吐，善太息，谵语。

舌质：红舌，边儿红，紫红，尖而红，稍红，暗红，淡红，淡，暗，或者紫暗，或者瘀点。

舌苔：黄苔，有黄腻苔，薄黄苔，厚黄苔，还有白苔，白苔里边包括了薄白苔，白苔，白厚苔，白干苔，另外呢还有黄白相间的舌苔。

脉象：脉象有弦脉，细脉，数脉，沉脉，滑脉。

现代应用：狂躁性精神病、精神分裂症、癔病、癫痫、神经官能症、舞蹈病、半身不遂、更年期综合征、失眠、巴塞杜氏病、神经性阳痿、男子不育症、肥胖症、肺结核、胸膜炎、支气管哮喘、心脏病、心脏血管神经官能症、窦性心动过速、心绞痛、房室传导阻滞、频发性室性早搏、冠心病、病毒性心肌炎、高血压、肝硬化、慢性胆囊炎、胆道功能紊乱、消化性溃疡、慢性胃炎、肾炎、肩周炎、脱发、湿疹、白内障、青光眼、结膜炎、美尼尔氏综合征、甲亢、弥漫性甲状腺肿、中耳炎、突发性耳聋、复发性口腔溃疡、脑溢血、脑震荡后遗症、脑炎后瘫痪、帕金森氏综合征、夜游症、婴儿痉挛症、小儿夜啼症、夜尿症、子宫内膜异位、

再给大家说一个医案。临近县有姓熊的一家人，那家人都属于神经比较敏感的，在我这儿吃药的有三口人，其中一个四十多岁的男士，他们的病几乎都一个原因，因为他的老母亲不在了，精神刺激比较大，

然后都出现一种神经质的状态。这个男人家里开了个小药店，他整天想着自己这儿不舒服了、那儿不舒服了，整天吃西药，越吃体质越弱，慢慢的就闹出一些病来，后来就来我这儿看。给他治疗的就是柴胡加龙骨牡蛎汤，还有像桂枝茯苓丸清瘀血这类的方剂，吃了以后很快就稳定住了，精神上是比较正常了，但是后来他又出现小便不利，又改成真武汤。他的妹妹跟他差不多的症状，腹诊的时候我说你胸口这个地方明显的跳，这是一个比较明显的指征。她看完病回去，过了一天她又特意给我打电话，她问我这个地方跳是什么病啊？是不是有不好的病？她就想很多，她又说她小肚子左侧摁一摁里边有个小硬块，她也感觉到了不得了，这病太大了，甚至班都不想去上了，后来我就给她解释解释。这次经前又来了，小肚子跳，包括精神方面的基本都没有了，但是她又好像是天生性格上稍微敏感一点，其它的跟常人没什么不一样。

伤寒、腹满谵语、寸口脉、浮而紧、此肝乘脾也、名曰纵、刺期门、（108）

胡希恕：这一条和下一条都有问题的，那么就这个证候呀，腹满谵语，是阳明病，胃不和者谵语嘛，腹满他里实，开始得的是太阳伤寒，腹满谵语就是传里了，传里发生阳明病了，但寸口脉呀还浮而紧，太阳伤寒表还没撤呀，还没罢，那么说明是太阳阳明并病，就是说太阳伤寒传里已经发生腹满谵语了，但脉还是表证没罢的脉，仍脉浮紧，那证候来分析呀，这是太阳阳明并病，那么这么闹的肝乘脾这就知道了，所以这不可理解的，名曰纵。刺期门。那么这一段呀在《医宗金鉴》中说这个一定有错误，我认为也有错误，前后语言不通俗，那么刺期门穴就好理解了，去胸隔的邪热，那么这一段没有胸隔的症呀，他有胸胁苦满可以勉强说，只是腹满谵语这是阳明病，脉浮而紧是太

阳伤寒脉，那么只能说是太阳阳明并病，下面的话有错，有遗误，这个《医宗金鉴》就这么说，那么各家说法也有不一的，不一的也说不出道理来，这我也都看过。

李冠杰：这一条在《康平本》里边是降两字格排版的条文，下边咱们就简单的解读一下：

这个“伤寒”肯定就是指的表实证了；“腹满谵语”常常就是阳明里热证的症状反应；“寸口脉”就是桡动脉，“寸口脉、浮而紧”，这个“浮而紧”这是典型的伤寒脉，就是太阳表实证的脉。从上边所论述的这些症状反应看：这个条文所论述的就是一种由伤寒表实证发展为阳明里实热证，而且伤寒表证仍然存在的一种病理状态，也就是我们常说的太阳阳明合病。下边来了一个“此肝乘脾也、名曰纵”，大家如果学过胡老的讲座的话，胡老的观点是非常明确的，实际上这就是典型的五行生克的推衍，在这一方面后边类似的条文还有，但是这一类的条文几乎都出自降两字格的条文中，也就是说都是出自王叔和之手。这儿不深入的去说那些理论上的，比如五行理论和经方理论它们的分歧在哪儿，总有机会说的，前面实际咱们说过。像“此肝乘脾也”，仅就这个条文而言，它也没法自圆其说，这里边就算按脏腑辨证看你也看不出有明显的肝的症状出来，它根本就没有，来这么一句让人不可理解。“刺期门、”这“期门”是一个穴位，“刺期门”就是用针灸的方法、用针刺的方法，去刺期门穴，用来治疗里热的，这个也仅做参考。这个要整体的看，咱们在这儿就讨论不是这一个条文本身的意义，是这一类的条文，它跟康平本里边所有降两字格的段落里边的内容，无论是理论观点上，还是论述风格上，都是一脉相承的，这肯定是一个作者，根据我们现在知道的它就是王叔和写的，像这些东西我们可以把它作为整体来看，我们可以把它作为研究王叔和理论的资料来看待，一定要把它跟经方理论分开。但是它毕竟是写在《伤寒论》里边，这里边有王叔和对经方理论的理解，对的我们就吸

收、我们就继承，不对的我们一定要把它分开来。像这一条“此肝乘脾也”之类的在经方里边没有这类的说法，与经方理论不相合，这一类的条文我们就不做小结了。

伤寒、发热啬啬恶寒、大渴欲饮水、其腹必满、自汗出、小便利、其病欲解、此肝乘肺也、名曰横、刺期门、（109）

胡希恕：太阳伤寒，发热，表证呀，啬啬恶寒病在表，咱头前讲过了，伤寒发热恶寒嘛，啬啬恶寒就是表证，大渴，里有热才大渴，本来太阳伤寒他要大渴也是病于里，渴而欲饮水所以其腹必满，他是大渴欲饮嘛，饮的多肚子就满，那么由底下这些症状，自汗出，这个伤寒是没汗的，自汗出当然这个表就自解了，小便利，这个水也有出处了，虽然有渴饮，一时腹满，但是小便利，水有去路了，这个满也自能消的，这样子其病欲解，这个是没什么大问题的，底下弄个肝乘肺也不可理解，这与肺也没关系，名曰横。也刺期门。

这两段你们回去看看《医宗金鉴》就有，他说这里头绝对有遗误，各家也没说出个子丑寅来，所以这个书错误也是有的，而且搁到太阳篇里有没有意思，以后也没提到肝乘脾、肝乘肺的证治。这两段根本都是太阳阳明并病，太阳病没罢，阳明病显了，只能看到这个，那么说这个纵与横，都是肝移热于脾，移热于肺，有问题的。

李冠杰：这也是一个降两字格排版的条文，下面咱们也看一看：

“伤寒”，指的就是表实证了；“发热啬啬恶寒”这也是表证的症状反应，那么“大渴欲饮水”这是里热的症状。这儿看，论述的也是一种阳明太阳合病的情况。

下边再看看“其腹必满”，这个“其腹必满”跟上边的“大渴欲饮水”有关联，就是说“大渴欲饮水”，他就饮水多，因饮水多而造成腹满。“自汗出”，这儿有一个“自汗出”，但是这个“自汗出”

不是指的上边的那个太阳病自汗出的意思。本来是个表实证，后来又渴，喝水又多，这时候有了自汗出的这一类的情况，实际上有里热证，也可能有“自汗出”的症状。但是这个地方它本意不是这个意思，它没有跟前边那个“啬啬恶寒”连为一体，不是那个意思。它是要说什么呀？要说这是有要表解的机制。

如果说细分析的话，这个病理上是一个挺复杂的事，既有表证，又有里热。那么有里热，比如麻杏石甘汤，就属于一种既有表证，又有里热，因为有里热而有汗出。但是这个地方“自汗出”不是那个意思，因为后边有“其病欲解”，“自汗出”，包括“小便利”，都是想说欲解的机制是什么。“小便利”就是人体机能趋于正常，要如果他小便不利的话，那么他还存在着体液代谢不好的问题。这个“小便利”，喝水也多，小便也多，人体有趋于正常的这种趋势，再加上又有“自汗出”，这时候“其病欲解”嘛。那么欲解的征象是什么？就是“自汗出、小便利”。

但是后边又来了一个“此肝乘肺也”，这个跟上边一样就不可理解，咱们也不去过多的解释了。再说，这些症状里边，你总感觉到他列举的这些症状，你分析来分析去，里边多少有点矛盾的地方。像这一类的条文咱们不去过细地推敲了，知道这么回事就行了。

这个也需要用“刺期门”来治疗，因为他有自愈的机制，那么“刺期门”，这个穴位可以用来治疗余热。

大阳病二日反躁、反熨背、而大汗出、大热入胃、胃中水竭、躁烦、必发谵语、（注）十余日·振栗·自下利者·此为欲解·（经）故发其汗、从腰以下、不得汗、欲小便不得、反呕欲失溲、足下恶风、大便硬、（注）小便当数·而反不数·及不多·（经）大便已、

头卓然而痛、谷气^②下流故也·其人足心必热、^①（110）

注：《宋本》此条文如下：

太阳病，二日反躁，凡熨其背，而大汗出，大热入胃，胃中水竭，躁烦必发谵语。十余日振栗自下利者，此为欲解也。故其汗从腰以下不得汗，欲小便不得，反呕，欲失溲，足下恶风，大便硬，小便当数，而反不数，及不多，大便已、头卓然而痛，其人足心必热，谷气下流故也。

②湖南科技版 1988 版无“谷”字，据叶橘泉 1947 版加。

胡希恕：以前的书也谈到火攻的危害，以下这些段落呀都讲的这个火攻对治疗的危害。“太阳病，二日反躁，凡熨其背，而大汗出，火热入胃，胃中水竭，躁烦必发谵语，十余日振栗而自下利者，此为欲解也”，这句话是个倒插句，接着“故发其汗从腰以下不得汗，欲小便不得反呕，欲失溲，足下恶风，大便硬，小便当数而反不数，及不多，大便已，头卓然而痛，其人足心必热，谷气下流故也。”这一段呢主要内容是火逼取大汗，伤津液。太阳病，二日反躁这头前咱们讲过，发病一日，太阳受之嘛，脉若静者为不传也，若躁烦脉数急者为传也，一般说太阳病在一二天的时候并不传，那么这个在二日反躁，这个躁，就是胃不和者躁，烦躁，那么这个说明什么呢？说明表多热，所以传里迅速，在第二天的时候就有传里的这么一个预兆，人就是烦躁，那么这说明里头有热了，里头有热更不能用火攻，而反熨其背，所以搁个烦躁，他不经常，经常这个太阳病呀在一二天里不这样，他不传里，也有特殊，这一段就是说这个胃伤多热的人，所以说二日就有这种情形了，既里头有热更不能用火攻，而已凡熨其背，古人有这么一个用砖和瓦，把它烧热，拿布把它包了，也有搁醋的也有不搁醋的，在人身上熨，用热的力量使人出汗，这是古人的一个……就是说胃中干啊，胃中干而不和，一定要躁烦，而发谵语，所以躁烦，必发谵语。原来就躁，那么由于这个火热入胃，胃中干，那么这个躁更加重，以至于说胡话，谵语就是说胡话。底下这句话，他说这个病的预后，那么到十余天的时候，这个病主要由于胃中干，丧失津液太多了，大汗出；那么津液恢复了，那么这个病自然就能够好。

等到十余天之后，如果这个津液恢复，可是仍要这个发生冥眩状态，振慄，就是打寒颤，战栗。自下利，那么津液达到下面，所以，它就胃干，胃气不能布于，尤其不能往下布。那么要是胃气恢复了，津液也恢复了，那么气由上注于下，发生振慄，而自下利，这个病就好了。这是一个倒装句，这句应该搁在后头。“故其汗从腰以下不得汗”，这是接着上面，躁烦，必谵语，这说明胃中干，而且有热，火热入胃，胃中水竭，所以汗呢，底下没有，只能够从腰以下不得汗，只能上头有汗，他由于津液枯竭，不足以利下。欲小便，不得，老想要小便，但是小便没有。“反呕，欲失溲”，这个反呕有两个问题，一个它是热往上涌，一个是由于下面还是有一种水饮、饮是饮，津液是津液，津液是由胃所生的，就是谷气，那么人的身上的水分是相当的多了，人身上的重量以水分为最多了，由于热往上，激动人身上的水气也往上逆反，所以也呕。那么冲着这段的治疗，哦，这个没有作出治疗，这段后头有。凡是呕啊，都是有水往上逆。所以这个呕有两个问题：一个是热涌，一个由于这个热激动里水而呕逆。“欲失溲”，水火这两样东西是不能并存的，热上，那么排出一定的水分，所以汗多。所以阳明病就有了，阳明病发过汗，小便也数。

那么，欲失溲，其实没有多少，欲失溲者，这有两种问题，一个是谷气不能下，不能布于下，下面虚，那么小便失于溲者，它要小便不解的，但是又没有津液，所以欲失溲，老想要失溲，但是而无溲可失，就是没有尿。足下恶风，那么人身上的体液不到哪个地方，哪儿就虚啊，所以津液不布于下，所以足下虚而恶风。大便硬，这也由于胃中水结啊，而大便是硬的，大便硬的情况，小便当数，这是定然的，常常说水谷不别，肠子里有水，大便溏，小便不利。反过来，大便干大概要小便频数的，按一般的前后二便的规律，那么这个情况不是，小便不但不数，而量也不多，欲失溲就是从这句话，既不多，那为什么呢？就是谷气不得下流。大便已，就照了这句话，十余日，振慄，

自下利，此为欲解也。这句话它放到头前了，就接着十余日，十余日，发生振慄这个人同时他下利，在这以后，头卓然而痛。头卓然而痛，骤然间，卓然，突然也，也是很明显，就是这个人到这个时候，津液恢复了，胃气扶正的时候，振慄，自下利，头卓然而痛，这是一句话，一起的文字，分成了两份，前后倒插句。其人足心必热，这时候这个人啊，底下不恶寒了，而还感觉足下热，其下不寒冷而足心有热。谷气下流故也，所以这个病就好了。这时候胃的津液恢复了，谷气也下流了，病就痊愈了。这一段主要是说明这么个问题，他有表证，如果里有热，更不能用火攻，如果用火攻的话，亦助其热，实际上表还未解，那么由于热迫使大汗出，丧失津液，里面的水分更枯竭了，尤其是胃，这时候这人胃气不和了，一定要躁烦，谵语。由于津液亏损，他的汗只能在上半身，腰以下没有汗，我们人身上的一切的机能全仗津液与血液（内经上的话），胃气嘛，脾为胃行其津液，津液到哪，哪能行，所以到手，手能握，到足，足能行。这个津液不能到下面，所以小便也失禁，但是没有尿，欲失溲，不是真正的失溲，足下也寒，津液达不到那儿，这是这个病理的前后的情况，可是这种病看看，但是没有特殊，没有什么特殊的险恶证候，他是一时的大汗出，里有热，津液虚。这种病能够治好的，自己好的。如果自己好的话，也不是三天两天能恢复，十余日的时候，津液恢复了，胃气和了，谷气也能下顾了。凡是虚证，我们先前说了他自愈的时候，用药对头了，好了，都要发生冥眩，冥眩是病欲愈的一种反应。这个病症愈冥眩的样子是振慄，自下利，头卓然而痛，这个病也就好了。这段主要讲这个，火攻啊，使内热加甚，胃中水干，而为上面所述的一系列证候。

李冠杰：这个条文文字比较长，而且里边也有一些值得推敲的地方。

这个条文里边有一些小问题，咱们一一的慢慢来看一看。

这个“反熨背”在《宋本》里边是“凡熨其背”，不是个“反”，

而是个“凡”，这个也没有很大的问题，就是字面上不太相同。

另外呢，《宋本》在这个旁注之前加了一个“谷”字，成了“谷气下流故也”，然后在篡入正文的时候，置于“其人足心必热”之后，就是放在这个条文的最后了，这个还不是特别明显，下边条文诸如类似的东西非常多，细玩味的话，里边还有其他的版本感觉不到的一些信息。

咱们先解读条文，“太阳病，二日反燥”，这说明什么呢？这说明人体里热比较盛，患了太阳病只有两天的时间，就出现了阳明病的证候，就是这么一个意思。

“反熨背而大汗出”，这肯定是错误的治疗了。这个熨法就指的是把药物炒热或者说砖瓦之类的物件儿烧热，用布包好，熨身上的某一部位。这种治疗方法是用来驱寒镇痛的，因为它能改善局部的血液循环。熨背是指用上述的方法熨烫患者的背部，促使他发汗，“反熨背”本身就说明了这是一个误治。本来人体就已经有了里热了，再用热的方法来治疗，这就是错误的。“而大汗出”，这里就有两个方面的意思：其一，太阳病应该发汗，但是应该服相应的发汗剂，而且让他微微汗出，熨背本身就是一个非法的治疗，再加上大汗出，这肯定对人体危害就比较大了。第二，阳明病，本来正常的应该按清里热的办法来治疗，以温熨的方法来治疗，不但会加重里热，而且还会造成大汗出，本身有里热环境再热了，大汗出就有这样一个因素。

“大热入胃，胃中水竭”，是对上述的误治做了一个病理的解释。就是说人的里热重了，致使津液虚损，这么一种情况。

“烦躁必发谵语”，这是阳明病加重以后的症状反应，一个是“烦躁”，严重了可能会发生谵语，说胡话。咱们把嵌注文字和所有的注解文字放在后边说，咱们就按原文直接往下学。

一看人的疾病不愈，这个时候“故发其汗”，就再用发汗的办法。前边熨背已经造成大汗出了，而且阳明病也已经比较严重了，医者看

见病不愈又给吃发汗药，这等于说是一误再误，病情必定会进一步得加重。因为前边大汗出和里热加重本身就造成了津液虚损，再发汗患者，没有那么多津液了，只能是上半身有汗出，而从腰以下不得汗。反复的攻法就致人身体虚弱，津液虚，这个时候人体对小便的控制能力也就有所下降了，自我感觉老是要小便，津液虚损到很严重的程度了，已经无便可排了，即感觉到“欲小便，而又不得”，甚至会出现小便近于失禁的情况“欲失溲”。

一般情况下阳明病很少会出现呕的情况，但是如果里热太盛，胃气不和，比较严重时候，也会出现呕，所以条文里边就有一个“反呕”。由于津液不足，下肢的津液尤其不足，缺少营养以后就感觉“足下恶风”，脚怕冷，而且“大便硬”，这就是有里热，津液又虚的一个必然结果。“大便已，头卒然而痛”，这应该是特殊的症状反应，我们今天临床当中碰到这一类情况很少，就是说解完大便以后突然发作头痛，头痛比较突出了。后边原文“其人足心必热”，就是说有人体津液恢复的一种变化。

但是这个地方，“其人足心必热”和前边明显有不相衔接的味道，这好像是中间缺少什么。再加上这个条文多处被后来作者加了嵌注和旁注，估计原文本身是不是完整，还值得研究。

这类条文不是一个方证条文，我们在这个条文当中要学的，是这个条文里边的病理变化，医治的道理，在这里边都蕴含着一些值得我们学习的东西。我们学习理解这里边的生理变化吧。

下边我们做一个小结：

患太阳病刚刚两天的时间，便出现烦躁，医者采用熨背的方法，致使大汗出，因外热加重了人体的里热，致使津液虚损，患者表现为躁烦，甚至可能发生谵语，医者见病不愈又予以发汗，但患者从腰以下不得汗，欲小便不得，反而出现了呕和欲失溲，脚下恶风大便硬的症状，而且患者大便后头卒然而痛，足心则会有热感。这是按照字面

意思的小结。

刚才和大家说这是小结，实际上只是文字上的直译。如果说要做小结的话，特别是“足心热”，本身前边有足下恶风，后边没有一个发展的过程就出现了一个足心反倒热，这本身就相互矛盾的，恐怕这里边缺少了一些文字。

那么嵌注内容呢，嵌注第一部分，就是说加入嵌注以上的情况，如果不经发汗治疗，经过十多天的情况患者若出现振栗，自下利的，是疾病即将自愈的表现；嵌注的第二部分是说本有里热，小便应该频数，但是患者小便并不数，而且小便量也不多，为津液虚损所致；那么旁注病人所以足心必热，是由于下肢的状态有所恢复的缘故，这是旁注的意思。

大阳病中风、以火劫发汗、邪风被火热、失其常度两相薰灼·血
气流溢、其身必发黄、（注）阳盛则欲衄·阴虚则大便硬·阴阳俱虚竭·身体
则枯燥·（经）但头汗出、剂颈而还、腹满微喘、口干咽烂、
或不大便、久则谵语、甚者至哕、手足躁扰、捻衣摸床、（注）
小便利者·其人可治·①（111）

注：《宋本》此条文如下：

太阳病中风，以火劫发汗，邪风被火热，血气流溢，失其常度。两阳相薰灼，其身发黄。阳盛则欲衄，阴虚小便难。阴阳俱虚竭，身体则枯燥，但头汗出，剂颈而还，腹满微喘，口干咽烂，或不大便，久则谵语，甚者至哕，手足躁扰，捻衣摸床。小便利者，其人可治。

胡希恕：这条关乎生死的问题。太阳中风，太阳病有两种，一种是伤寒，无汗的；一种是中风，有汗的。太阳中风这种证候啊，他是津虚多热，所以桂枝汤所主证候没有不发热的。假若以火劫发汗，不得了，用麻黄汤肉桂心以火劫发汗迫使大汗出。邪风，就是风邪了。风邪这句话，有语病，等讲完了再谈，外邪使人发热，他本身也是热，

再被火热，又加以被火，用火开始迫使发汗了，其势如焚，本来就热，续之以火，邪热因火而盛，加重火热，所以血气流溢，血气流溢这四个字也挺复杂，它是血流散，而气溢出。血流散于脉内，血在血管里头，古人认为血管里头就是血，血流散于脉内，气呢，血管外头的这种液体就是气，而气逸失于脉外，逸失于脉外就是汗了，所以血气流溢，溢者，溢出也。失其常度，人的气血在有的时候是有常度的，这种物质，失其常度。两阳相熏灼，两阳，外邪为热，用火攻，火也是热，热者为阳，所以两阳相熏灼。

本来有风邪，又被以火攻，这就是两阳。两阳熏灼人的什么地方呢？就是肌肉啊，筋骨肌肉。其身发黄，这个发黄不是黄疸，火熏的呀，我们通常讲温病，用火攻之，其身如薰黄，像火熏的发黄。阳盛则欲衄，热往上亢，阳热亢于上，人一定要出血。阴虚小便难，水竭于下，那么小便就艰难了，欲小便而不得。和上面的一样。阴阳俱虚竭，这个阴阳，它指气血来说的，那么气血就是血管外血管内液体全虚而且少。俱虚竭，身体则枯燥。我们讲竹叶石膏汤，身体羸瘦，丧失体液太多，人马上就瘦下来了，就像衄家不可发汗，发汗额上陷，都一样。津液丧失，丧失血液，人很快就消瘦，所以身体就枯萎而燥，燥就是热。但头汗出，剂颈而还，热当中，热气往上攻尤其津液虚，他身上不出汗，只是脑袋出汗，就是脖子以下没汗，以上有汗。剂颈而汗。腹满，微喘，热往上涌，同时里头也干了，胃里头有燥结了，燥结列于腹，压迫腹膜，就腹满，微喘。口干咽烂，就是热太甚，热壅于上，口干，嗓子也烧坏了。或不大便，解不出大便。或者大便干，大便硬，阳明内结，一定要说胡话，甚者至哕，这个津液再虚到家，胃气也就要败了。至哕，这是虚极影响脏器机能，尤其胃到了这种极其危险程度了。手足躁扰，那么这时候人体的神思就不守了，手脚躁扰，没处搁，没处放，但人是不知道的，所以紧接着讲捻衣摸床，这是最险恶证候，捻衣襟边，摸床沿，人要死的时候，是有这种情况，

这是病实证虚了，人身上的机能虚到家了，他没意识的举动，所以捻衣摸床，什么也不知道这是危乎殆的。如果津液要是恢复，小便利了，其人可治，否则就不行了。那么这一段与上面不同，比上面严重。尤其虚，津液虚而有热，更不能用火攻。头一段只是里有热，并不虚。如果是太阳中风，要是用火劫排汗，更危险，这段主要是这个问题。

李冠杰：“太阳病中风，以火劫发汗，邪风被火热”，下边加了一小段旁注：“失其常度两相熏灼”。再往下是正文，“血气流溢，其身必发黄”，接下来是嵌注：“阳盛则欲衄，阴虚则大便硬，阴阳俱虚竭，身体则枯燥”，下边是正文，“但头汗出，剂颈而还，腹满微喘，口干咽烂，或不大便，久则谵语，甚者致哕，手足躁扰，捻衣摸床”，再往下，到最后就是附注了，这是一个注解：小便利者，其人可治。

像这类的文字，都有它跟宋本的比较，我这还附有宋本的原方，我们就不去再读了，大家有兴趣可以对比一下，因为这不是很重要的条文。需要跟大家说明的是明显存在不同的，条文里“其身必发黄”，宋本作“其身发黄”，没有必字。“阴虚则大便硬”，宋本里是“阴虚则小便难”，这儿的区别就比较大了，这肯定是有意改的。

咱们解读一下：

“太阳病中风”，就是指的阳性表虚证，太阳病中的中风证。

“火劫”指的是用温针、艾灸、或者熏，或者熨等方法，劫迫发汗，这个劫字在这是迫使的意思，“以火劫发汗”就是用上述的方法强行使患者汗出，跟刚才那个一样。但是这个方法从字面上说就宽一些，那个熨背只是火劫的一种。

“邪风被火热”，邪风这两个字出在了顶格条文里，像这类的说法是古人在当时的历史条件下对外界的风致人体得病的一种认识，就是说对外界各种因素致人体得病的一种认识，风也好，寒也好，伤寒论对这类东西的认识，相对说比较客观一些。《伤寒论》第二条名为

中风，第三条名为伤寒，就是说把它叫做这个，所以说书的作者对这些地方认识的还是比较客观的。但是限于当时那个环境啊，这样说就比较容易理解，就跟现在一样，如果跟病人说你受到病邪的侵扰，病人会觉得你这话很奇怪，你换一种方式说有细菌病毒之类的东西造成的疾病，他就觉得很容易理解了。在当时也是这个样子，就现在中医里说邪风大家也都认可，也都知道是什么，但是如果仔细分析，应该说这种说法最起码不科学。古人认识风属阳，就是说它是阳性的，而因风所致的病也是属阳性的，火也是阳性的，它也是热性的这种因素，所以说，如果像邪风这一类的被火以后，等于就是两个阳性的加在一块了，旁注里说的更明确一些。总之，还是受当时局限的一种说法，如果我们今天解读，就是说太阳中风，具体说桂枝汤证本身就属于虚证，从临床实践中证明，对这一类的方证如果用火劫的方法强行发汗的话，就容易出现条文里论述的这种不良的后果——血气流溢，就是指火劫以后人体津血大量的损失。“失其常度两阳相熏灼”应该是对血气流溢的机制所做的解释。

“其身必发黄”，这个地方胡老解释的非常到位，是火劫的方法致人身黄，而不是发生了黄疸，这没有造成黄疸病的机制。

“但头汗出，剂颈而还”，这是津液虚损严重，虽然有里热蒸汗外出，但是也只能是头部有汗出，头部以下就没有汗出了，这主要是津液虚的问题。

“腹满而喘”这是阳明里热的反映，它的机理是里热造成了胃中燥结，压迫横隔膜致使人发生喘。这个腹满就是肚子里边满了，同时又有喘，这个时候喘就跟里实有关系，是里实造成的。

“口干咽烂”，这本身涉及到一个病理的问题，像腹满而喘就不能把它看作两个孤立的症状，“口干咽烂”是里热上涌造成的。

前两天有一个病人咳嗽，我从头问到尾，我感觉他是一个柴胡证，后来我给他做了腹诊，就是胃部这个地方感觉有抵抗感，摁它有些硬

的感觉，但是他本身没有痛或者满闷的感觉，他大便还次数有点多。我后来想来想去，就给的大柴胡汤，因为他热证比较明显，大柴胡汤加点石膏给了两天的。因为他有一天解两次大便的情况，虽然不偏溏，但是毕竟是大便通，而且比正常大便次数还要多，但是想想他因为没有别的证，我就给他大柴胡汤，给他两天的，跟他说喝了以后还好不了的话，或者有不舒服的感觉再回来，现在过去五六天了也没回来。这是个老病人了，如果有问题肯定会来电话了。这个就是明显的一个里实合并半表半里有热，就造成了咳喘的这种情况。

“或不大便，久则谵语”，不大便为阳明里结的结果，如果时间长了老不愈，就会引起胃气不和，严重了就会出现谵语说胡话的这种情况。

“甚则致哕，手足躁扰，捻衣摸床”，这是病情进一步的恶化，出现了危相，这个哕既不是阳明病，也不是少阳病呕吐的那种症状，实际上这是一个比较重的问题，因为胃气衰败，胃里装不下东西了。

“手足躁扰，捻衣摸床”，这是患者病实人虚，在非常严重的情况下出现的神志不清，手足躁扰。捻衣摸床在中医里都有专门的名词解释，手足躁扰指的是手足扰动不宁这样的症状，后边还有一个解释，就是说多由实热内扰，或者正虚邪实神不自主所致，这一条里实际上这两个因素都有；捻衣摸床是病人神志昏迷的情况下，两手不能自主的抚弄、捻搓手边的衣物等物件。这个条文述的重点就是太阳中风，阳性表虚证，不能使用火劫的方法治疗，否则就会出来严重的失误。

下面做个小结：本为太阳中风证，医者反以火劫的方法强迫发汗，中风证被火劫之后，身要黄，只是头部有汗出，致颈部而止，腹满微喘，口干咽烂，或不大便，如果长时间不愈，则会发生谵语，严重者则会出现哕，手足躁扰，捻衣摸床等危症。

这个条文里有多处注解、嵌注。第一部分说的是中风证被火劫之后，阳气盛的容易发生鼻衄，阴虚的则会大便难，如果阴阳都虚竭，

身体则会发生枯燥；嵌注的第二部分它说的本条文所论述的这种情况，如果患者小便利，则有治愈的可能，应该是一个危症，很重；旁注说中风证被火劫之后，中风和火劫两个方面的因素，致使人体生理功能失去了正常的状态。

伤寒脉浮、医以火迫劫之、亡阳·必惊狂、卧起不安者、
桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之、（112）

桂枝三两去皮 甘草二两炙 生姜三两切 大枣十二枚擘
牡蛎五两熬 蜀漆三两洗去腥① 龙骨四两

注：“洗去腥”《宋本》作“洗去腥”。

右七味、以水一斗二升、先煮蜀漆、减二升、内诸药、
煮取三升、去滓、温服一升、（注）本云桂枝汤·今去芍药·加蜀漆牡蛎龙
骨·

胡希恕：这段说的是太阳伤寒了，上面说的是太阳中风。太阳伤寒，他不虚，表实证。伤寒，没有汗的太阳伤寒的这种类型，如果以火迫劫之，劫之，就是劫汗，劫使大汗出。亡阳，必惊狂。如果是大汗，汗出太多就亡阳，亡阳，就是亡失津液，那人一定要惊狂。为什么要惊狂呢？这里头过一会儿再讨论。方才的风邪我要说还没有说呢。由于大汗出，桂枝加甘草汤的“心下悸，欲得按”，大汗出，伤津液就亡失血液，津液丧失血液中的液体也丧失了。血不足以养心，心气虚，他就微惊微悸，这是一。第二呢，他本来就是伤寒，而以火攻迫出大汗，邪热返助，火热返助邪热，热更加重，又由于大汗出而导致气上冲，上下体液骤然间失调，下边的体液就往上，冲气、邪热攻于脑，也发于惊狂，所以这个惊狂不仅属于心脏，脑系也有，所以亡阳必发狂，亡阳两字用得相当的好。由于火热，不到亡阳的这种程

度，未必惊狂。如果达到这种程度，一定要惊狂。第一个，血不足以养心，心怯则惊。另一个导致气上冲，气上冲，不断热往上冲，导致水也往上来，影响脑系，也使得惊。惊狂已经达到卧起不安，这个要用桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤。就这个方子来看，我们知道惊狂也与水有关系，因为它用的是蜀漆，蜀漆就是常山苗，它能够去水饮，治内里头有痰结；也是一个安神药和龙骨牡蛎差不多，都能治胸腹动悸、发惊发慌，就是现在说的神经官能症，有镇静作用。这个方子是以桂枝去芍药汤为基础，可见这个胸满，张仲景讲这个桂枝去芍药汤“脉促胸满者桂枝去芍药汤主之”。那么这个用桂枝去芍药汤的基础绝对不是胸满，它这个胸满就我方才说是汗出太多，导致气上冲，下边的水也伴随气往上冲，胸满动悸而卧起不安。它这个表未解，以火排泄大汗，所以呢，仍然用桂枝汤，伤寒原本是无汗的，一定是大汗出，到亡阳的阶段了，这时候表虽然未解但不能用麻黄汤了，必须用桂枝汤。它由于气上冲的厉害，上边冲下边虚，所以去芍药。用桂枝去芍药汤还是治胸满表不解，另外有些神经症状，他加安神镇静药，里面用蜀漆、龙骨牡蛎。也就是说这个方剂桂枝去芍药汤证而精神失常，有惊狂而卧起不安的时候可以用这个方子。这是根据这个方剂来分析这个证候。

上面我说的风邪的问题，作个讨论。可见仲景这个书啊，它也说邪风在人身上似的。所以也是错的。这在中医的理论上，中风伤寒，我讲了，不要以为真有什么风中到我们人体了、有寒在人体了。中医啊，这句话有语病，其后是很多的不科学的说法吧。说桂枝是祛风的药，麻黄是散寒的药，其实是不是由风带来的，由寒带来的啊，没有。即便是我们这个病由于受风而发作，它不过是个诱因而已。这个风是诱因，这个风不能呆在人身上，就像我们触了电，触了电有什么证候你就治吧，不能说电还在你身上啊。没那个事。所有研究中医，它的规律对不对，仍然是对的，到现在也是。我们对这个太阳病，两个类

型。一个类型发热汗出恶风脉缓，古人叫中风，我们现在叫中风也可以啊。还有一个类型，就是发热无汗，身体疼痛，甚至于不汗出而喘，这种情况，这个就叫伤寒。就这两个类型。现在人在临床上这个类型还存在，这个规律是古人通过实践发现的一个客观存在，多少年也不会变。我们治疗也不会变，桂枝汤的确就是治发热恶风汗出脉缓这一类的表证。是不是有祛风的，这个值得研究。所以我们研究中医，这些个地方要注意的很。那么这些理论站不住脚，站不住就不要这么来认识它，我们现在应该重新认识。我认为研究中医应该这样，要不然，就是不好的，明明是不科学，咱们还是说那就是风，就是风邪在身上，这个药还是驱风的。这个东西限于当时的科学水平，他无法认识它。恶风，中风病它是恶风，恶风就是风，风邪在身上的，伤寒的恶风和恶寒差不多，没有汗的，古人就认为是寒。后世的温病说夏天的酷热也跑到身体上来了，药治疗也是祛温祛热。这个也值得考虑，不能说发病这东西，而且这也不是主因。现在知道的伤寒是有病菌的，身上潜伏病菌了，因风因寒而诱发，仅仅是诱因而已，主要还是伤寒杆菌。这个地方研究中医，古人错了就是错了，认为风邪，后世多了，风为阳邪，甚至脑溢血，也认为是风，也得祛风。医学上很出了一些个偏差。这个地方，我们研究中医呢，古人掌握的规律是对的，多少年也是对的。通过实践，通过对规律的认识，那时候限于科学水平，他满脑子在想，在从现象到本质，我们说的中风伤寒就是拿现象当了本质了。中风由于出汗而怕风，他就说这为风邪他就起名叫中风。伤寒就是恶寒。古人的这种说法当作术语来看呢还行，真就认为风在这呢、寒在这呢是值得研究的。我不那么认为，证候是自然存在的，风邪的说法是值得研究的。

李冠杰：伤寒脉浮，医以火迫劫之，这儿加了一个旁注，亡阳必惊狂，卧起不安者，桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之，这个条文是一个顶格的条文。

下面解读一下：

“伤寒脉浮”，就是太阳表实证，医以火迫劫之，这个地方跟 111 条的误治方法应该是相同的，但是由于人体的状态不同，人体的健康状态不同，误治后的结果也不尽相同。旁注“亡阳”这两个字本身可有可无，加的有点多余，这个一看就能看出来，而且上一段条文里边对这种情况说的都已经很明确了，这个地方加它也没有多大的必要，但是它也不碍事。“必惊狂，卧起不安”，“惊狂”指的是神志失常惊恐狂妄的病症，就是说太阳伤寒如果用火迫劫的话，有可能发生此类的症状，并且还伴有坐卧不宁的这种状态。从治疗方剂来看这个方证，从病理上看非常简单并不复杂，它实际上就是桂枝去芍药汤加上了龙骨和牡蛎，它的方证也就是桂枝去芍药汤证的基础上又增加了体液代谢不好，有一个蜀漆啊，它就增加了体液代谢不良而且气上冲严重，以至于引发精神方面疾病的这么一种病理。按照我们的病理体系辨证把它规范一下，这条所说的病理就是阳性的表虚证合并水实证合并气逆证。这里就有一个问题，这个方证里边有一个很明显的指征就是精神方面的疾病，关于精神方面的疾病，我在归纳这些病理辨证的时候对它考虑了好多次，感觉这一类的疾病大部分都是在某一类疾病的基础上发生的，像柴胡加龙骨牡蛎汤是在少阳病的基础上，还有桂枝甘草龙骨牡蛎汤也应该是在太阳病的基础上，再加上这一类的方证也不是很多，还有因为有热证严重的，有的是因为里实证严重的，有的是因为血证血实证血瘀证严重造成的精神方面的一些疾病，精神疾病都是在这些类型的基础上发生的，所以我们没有把这种精神疾病这一类作为一个病理辨证的一个要素把它安放到病理辨证的范畴里边，而是把它当做一个特殊的症状来对待。

下边作一个小结：本为太阳伤寒病医者反用火迫劫发汗，如果致使患者发生惊狂卧起不安的为桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主治之证。

这个方子一共有 7 味药组成，实际上就是桂枝去芍药汤又加了蜀漆和龙骨牡蛎，咱们看看蜀漆这味药，蜀漆也叫常山苗，这味药用的机会不是很多，而且还不太好买，它是虎耳草科植物黄常山的嫩枝叶，也叫常山苗，也有叫它鸡屎草的，也有叫它鸭屎草的，它是一味温性的去水安神的药物，有一定的毒性。有一个关于药物方面值得我们注意的，这个方证它的用药思路与柴胡加龙骨牡蛎汤非常相似，只是疾病的基础类型不一样，柴胡加龙骨牡蛎汤是半表半里的虚证，这个方证则是以表证为基础了。但是都同时存在着一个停饮的问题，柴胡加龙骨牡蛎汤里边用的是茯苓和铅丹，这个铅丹待会儿简单说一下，上次学习的时候急于收场然后把这个铅丹给漏掉了。这个方剂里边用的蜀漆，为什么柴胡加龙骨牡蛎汤里边不用蜀漆？铅丹也有毒，但是蜀漆不仅仅是有毒的问题，如果大量使用的话，它能致人吐。换句话说它不太适合里虚证，这样大家就比较容易比较了，因为它是一个小柴胡汤的基础，有一个里虚证的因素。铅丹毕竟是一个毒性比较大的东西，我们用蜀漆代替行不行呀？从药性上来说完全可以，里虚不重的话用蜀漆没有太大问题，它的作用差不多，如果里虚明显的话，那用蜀漆就不太合适了。这个方证就是桂枝去芍药汤为基础的，它基本上没有里证的问题，用蜀漆疗效会好一些。

铅丹是镇静同时，它有一个很重要的作用就是坠痰，《药典》里边有这么两个字，其它的功能在这儿跟我们联系不大。铅丹本身质重，除了镇静以外它也有去水的功能，坠痰就是说它也有去水的功能。所以品味这些药味之间，你才发现慢慢能发现药物的一些特性。

下边看方证，这个方剂的适应症统计资料里边统计到的医案不多，一共统计到了 15 个医案。

症状：惊恐，这是排在首位的，它原文是这样的：在惊恐的后边打了一个括弧里边写了一个“叫”字，也就是说包括有一些精神方面呀，狂呼乱叫的这么情况都有，这是惊恐。再一个就是烦躁、心悸、

睡眠不佳、胸闷、肢冷。

舌象：舌淡、舌暗、舌绛、舌少津、舌苔呢；白滑苔、白腻苔、无苔、苔白、少苔。

脉象：细弱、弦细、浮细数、结脉、代脉、缓脉。

现代应用：早搏、风湿性心脏病、心脏神经官能症、冠心病、心律不齐、心肌缺血、房颤、高血脂、高血压、多动症，精神病，精神分裂症，癔病，精神抑郁症，烧伤、烫伤、误施灸、煤气中毒、热射病，这些都比较特殊的病，特别是烧伤、烫伤可能是有一些精神方面的问题，另外他有桂枝汤的基础，可以改善体表的血液循环，对一些体表性疾病应该有好处。

形作伤寒、其脉不弦紧而弱、弱者必渴、弱者发热、被火必谵语、弱者发热、脉浮者、解之当汗出愈、^①（113）

注：《宋本》此条文如下：

形作伤寒，其脉不弦紧而弱，弱者必渴，被火必谵语，弱者发热脉浮，解之当汗出愈。

胡希恕：形作伤寒，他的病形像没有汗的伤寒，也发热恶寒，但是脉呢，它不弦紧，伤寒是表实，脉浮紧，弦紧这个脉是很不好分的。弦，从上下绷之叫弦，绷直力非常强，脉管紧束有力叫做紧，这两个脉，脉紧无弦，这个脉不很好分的。跟这个缓弱一样，弦对这个脉就是弱，就像琴，才上的弦，用手弹弦，琴弦非常的直而有力，日久而不上弦，弦就软了，用手一按就弱了。缓是对紧说的，烟卷卷的松一按就是缓，卷的紧按就紧。紧和缓，弦和弱，是对着的。但是缓与弱是不好分的，所以书上太阳中风有时候是缓，有时候是弱，在理论上是存在，在指下很难分清。不弦紧而弱说明什么问题呢？津液虚，很好理解啊，脉管里充血脉管就紧，血少，松，脉就弱。这个我们讲过，大家想一想，用什么治法？头前有这么一句还记得不记得？“太

阳病，发热恶寒，热多寒少，此无阳也，不可发汗，宜桂枝二越婢一汤”，有这一节吧。这里是脉弱，脉弱说明没有津液，它不是阳气重于表，这就是体表津液不舒。所以发汗是不能的，更不能用火攻。所以津液虚，人要渴的。所以脉象前后看就知道了。热多寒少津液虚可以治，被火必谵语，所以津液虚以前就有了，这时候用火攻，那一定火邪入胃，胃中水竭，发热，一定要谵语。弱者怎么治呢？弱者要是发热脉浮，解之当汗出愈。解之，不是要你大汗，这跟我们那节一样，“此无阳也，不可发汗，解之”，用小量药清肃内外，解之就可以了。你们看看桂枝二越婢一汤，那个药量非常轻，石膏多少？此无阳也，阳不是热。太阳病发热恶寒，热多寒少。这个此无阳也不是没有热，无阳也就是津液没有，麻黄汤解之于表也是津液失于表。

所以这一段，注家都注错了，尤其是《医宗金鉴》就说这个弱者错了。弱者不能发热啊。其实是没有看到头上的那一节。这本书啊，熟读一遍是不行的。我19岁开始念伤寒，我今年80多了，我也不知道有多少个改变。你要不整个看下去，没个明白。这一段就是，我一说那一段，你们回头看看就明白。前后一看，原来是这么回事。像这段，形作伤寒，文字就前后不一致。太阳病发热恶寒，热多寒少，脉微弱者，此无阳也，不可发汗，宜桂枝二越婢一汤。这个形作伤寒，也是没有汗，脉不弦紧而弱。其实是一个东西，两种说法。读书呢要前后对照，单看一段，越看越糊涂。你们看各家的注都注错了。这就是说有表热，津液虚，脉就弱。甚至于微，这发汗就不行了，用麻黄汤都不行。用火攻更不行。那怎么办呢？脉弱的，解之，当使汗出。不能发汗。微微解之就可以了，稍微出点汗，病非常轻。

李冠杰：这个条文在《康平本》里面是降一字格条文，“弱者发热”这个旁注在《宋本》里面没有了，去掉了。还有条文里面“脉不弦紧”，在《宋本》里面是“脉不弦紧”，《宋本》里面“不弦紧”是对的。

这个条文里面的旁注“弱者发热”，《宋本》里面没有了，在《康本平》里面夹在“弱者必渴”的后面的一个旁注，大家有没有这样一种感觉，就是说有点多余。

下面呢我们解读一下：

“形作伤寒”，这个患者至少具有某些太阳伤寒的基本特征，比如发热无汗等等。

但是“其脉不弦紧而弱”，也就是这个脉啊，既不弦也不紧，表现出一种弱脉。

“弱者必渴”，脉弱同时又伴有口渴，说明人体的津液虚，这个脉弱也是津液虚的一个征象。

像这种情况，本来津液就虚，如果这个时候再用火攻，本来胃中的水份就少，津液进一步的虚损，达到了胃中干胃气不和的这种程度发生谵语了，津液虚的情况下，你再有热的因素诱发，容易形成里热。

那么条文说的是另一种情况了，如果脉弱的同时又表现为发热，脉浮的话，可以用发汗的方法来治疗，“解之，当汗出愈”，实际上这儿说的就是桂枝汤证。

下面呢做个小结：患者有伤寒证的基本特征，但是脉象却不弦紧而是呈现弱脉，弱脉则可能出现口渴的症状，此时如果用火攻的方法治疗则可能致人谵语，那么如果脉弱的同时又发热而且脉现浮象可用适当的方法发汗治疗。

大阳病、以火熏之、不得汗、其人必躁、到经不解·必清血、名为火邪、（114）

胡希恕：以火熏之也是一个取汗的方法。古人把那个地烧的很热很热的，然后在热地上躺下，熏而出汗。这叫火熏的方法。咱们用热炕多烧火也可以达到这种目的。以火熏之，不出汗的很少。但是如果

津液亏，津液虚，他就没有汗。他这个不得汗就是指津液素虚，以火熏之，不得汗，不得汗而邪出不去，而火热攻于里，其人必躁。躁，就是烦躁了。乱者为之躁，烦者为之热。热烦躁扰，躁比烦厉害。太阳病自愈的话都是七天，前面有啊。太阳病，发于阳，七日愈，发于阴，六日愈。在表的病自愈都在六七天。到时候不愈，而且外邪火热壅然不解，久之必伤阴。所以必清血，热不得外越，表证好的不好的，伤于阴血，一定要便血的，这种便血不是因为其他的问题，是火攻造成的，所以叫火邪。可见这个血用一般的止血法不行，应该去火热为要紧的，但这里没有说治法，有表不解，还得解表。表要是解了，像竹叶石膏都可以。但他不讲治法，这个火攻，没有提具体的证型，有的只是提及危害，不提证治，只提概要。具体情况具体分析，随证治之。

李冠杰：“太阳病，以火熏之，其人必躁，到经不解，这个‘到经不解’是个旁注，必清血，名为火邪”是一个顶格的条文。

因为条文的内容比较少，比较简洁一些，我们先做个直译：太阳病，如果以火熏的方法治疗而不得汗出的，患者可能出现躁的症状，可能便血，就此类我们称之为火邪。到经不解容易误导别人，今天解读把它理解成经过一定的时间病不得愈，这样理解比较客观。

下面重点说“火熏”，胡老有个理解就是将这个地或是炕加热了，让人躺在上面促使发汗这么一种方法。“火熏”我查了一下资料没有，这个熏字里面也不是这一类的治法，我觉得胡老的解释还是比较客观的。这个条文论述的是一种表实严重的病人，以火熏的方法，就是说把地烧热了或者说弄个热炕，让人躺在上面，让他出汗治疗。这个外热的作用，欲使人体的津液以汗出的方式排出体外，但是因为表实比较严重，有汗出不来，这个时候患者就会出现烦躁的症状，这个疾病的机理就跟大青龙汤证的机理有点相似：表实证严重，外界的热造成里边温度提高（不是里热，有一点里热），它需要以出汗的方式把温

度降下来，本身就想让他发汗嘛，因为表实的厉害，有汗出不来，里边的热又不能随着汗出来，这个时候热不得外越，就可能造成一些内出血的情况，像便血就是这一类的。凡是这一类的情况，就把它叫做“火邪”了。

火邪^①、脉浮热甚、而反灸^②之、此为实·实以虚治·**因火而动、必咽燥吐血、**（115）

注：

1. 《宋本》无“火邪”二字。
2. “灸”《宋本》作“灸”。

胡希恕：脉浮，热甚，这也是太阳病了，太阳病，脉浮，热越厉害，应该用清凉解表的，解表药里头也要用石膏了。而反灸之，火攻了，这个灸，就是我们常用的灸法了，这里不利于热实，脉浮，热甚表实证了。实以虚治，热实之证而以虚寒的方法来治疗，灸就是来治疗虚寒的方法，因火而动，必然要吐血，本来就热甚，继之以灸火，反助其热，热因火动，必咽燥，吐血。凡是热都往上涌。尤其在表证的时候。嗓子干，甚至吐血。这个热病不必用灸。有些热病，你用热药也可以使人吐血。治病，火攻与用药也有关系，所以必须知道寒热虚实，必须掌握这个。热要用寒治。热要是用热攻，必造成误治。

李冠杰：“火邪，脉浮热甚，而反灸之，因火而动，必咽燥吐血”。这条别看文字不多还好多问题，这也是一个降一字格的条文。最前边的“火邪”两个字，到了宋本的时候就没有了，宋本当中没有这两个字，还有康平本里边的“灸”字，在宋本里边是个“灸”字，这个灸字应该是对的，康平本里边好几处都是（灸字），应该是抄错了，这个字非常像，把这个“灸”字误抄成了“灸”字，我也查了下资料，考虑到他如果指的是用“灸”的办法治病？后来我查资料，中医的治疗上没有灸这个办法，这就纯属传抄过程中的笔误。

“火邪”这两个字实际上挺重要的，火邪指的就是上一个条文明确说了“称之为火邪”；这两个字就指上一条文论述的那种情况。下边做个直译：如果说表现为脉浮而且热甚，反而在这个时候再用灸法治疗的话，里热因为灸法会进一步地加重，就可能会出现咽燥吐血的症状。旁注的意思就是说，火邪为实证，而灸法是治疗虚证的方法，所以说不太配套，它大概就是这么一个意思。

微数之脉、慎不可灸、因火为邪、追虚追实·则为烦逆、血散脉中、火气虽微、内攻有力、焦骨伤筋·血难复也、①（116）

注：《宋本》此条文如下：

微数之脉，慎不可灸，因火为邪，则为烦逆，追虚逐实，血散脉中，火气虽微，内攻有力，焦骨伤筋，血难复也。

脉浮宜以汗解用火灸之、邪无从出、因火而盛、病从腰以下、必重而痹、欲自解者、火逆之也·必当先烦、乃有汗而解、

（注）何以知之·脉浮·知汗出解·（116）

注：《宋本》此条文如下：

脉浮，宜以汗解，用火灸之，邪无从出，因火而盛，病从腰以下，必重而痹，名火逆也。欲自解者，必当先烦，烦乃有汗而解。何以知之？脉浮故知汗出解。

胡希恕：“微数”，脉微而数。微者，血不足。数是有热。这就是虚热的一种病，津液虚而有热。“慎不可灸”，火也是邪，热邪，火与原来的证候之热，火更助其热，一定要烦逆。逆，也是多种，咳逆，呕逆。热要往上，热逆于上，追虚逐实，本来这个病是虚，因灸火的关系，越灸越虚，本来热实，继以灸火，更助其实。“微数之脉”，一方面是正虚，津液虚；数者，热，一方面是热实。这两个问题，津血越少，“血散脉中，火气虽微”，灸火之气，看着不怎么的，但是对虚热之证内攻相当有力。焦骨伤筋，血难复也。正因为血热伤阴，

这个血很难恢复。这在《金匱要略》痉湿喝里面有这么一段“痉病，由灸传者难治。”这是什么意思，就是这个意思，津液枯燥，肌肉不和，发痉挛。津液恢复，痉挛就好，由灸传，就是太阳病的时候，虚热的证候，灸者，血气难复，痉就难好。他和这一段是有关系的。“脉浮，宜以汗解，用火灸之，邪无从出，因火而盛，病重腰以下必重而痹”，火逆也。脉浮，病在表，太阳病，无汗的用麻黄汤，有汗的用桂枝汤，都是以汗解。如果用火灸之，用火来灸，邪无从出，这个邪，本来汗从表解。因为灸，邪不得从表而出。灸不能发汗，反而因火而盛，外邪因火反倒更热。刚讲了，麻黄汤证，体表充斥津液不得汗，热不能解，津液也不得出，热上亢，人身上的体液也不得汗，湿邪下注，所以这个病变成腰以下必重而痹，重，沉重，痹，痹而不仁，也可以疼，这是湿，这个湿哪儿来的？本来表证的时候体液大量壅于体表，太阳病的时候讲，机体让大量体液壅于体表以发汗解除疾病，用火攻不得出汗，热不能解，体表的湿，体表的水分只能到哪儿去呢？只能注入下半身，为痹。这是因火而造成痹证。“欲自解者，必当先烦，烦乃有汗而解。何以知？脉浮，故知汗出解”。这个病可以自己好，这个也是一时的情况，不能出汗，先前讲过：阴阳自调者，必自愈也。表里没有什么大问题，仅仅是腰以下重而痹，没有其他的问题，如果津液恢复了，自然出汗就好了，所以欲自解者，必当先烦。这也是凡是误治之后，身体要好过来多少要发冥眩状态，这个烦也是冥眩状态的反映。烦乃有汗，烦躁之后出身汗就好了。何以知之，为什么知道是这么出汗而好呢？“脉浮，故知汗出解”，由于火灸之后表不解，脉浮，病还在外，所以它要自解，总得要自汗而解。如果不自解还要治，也得解表。据我看还用桂枝汤。如果吃完桂枝汤，热解了，腰以下还重而痹，那你得想法治这个，大概得用苓姜术甘汤。苓姜术甘汤治所谓肾着汤，主要治腰以下沉和痛。这段脉还浮，表未解，邪无从出，当时就有这种情况，如果自愈的话，也得出汗。烦躁，出身

汗就好了。如果不自解，那得治，怎么治呢？解表，也得出汗。不然的话，身上的水气去不了。原文没有说治疗，但是治疗也在其中。

李冠杰：“微数之脉、慎不可灸、因火为邪、追虚追实·则为烦逆、血散脉中、火气虽微、内攻有力、焦骨伤筋·血难复也、（116）”这是第一部分，它还有另一部分。在《康平本》里边是两部分，在《宋本》里边这是同一段。

这个条文也是一个降一字格的条文，在《宋本》里边和下一条是同一个条文。《康平本》的这个旁注“追虚追实”，到了《宋本》又改成了“追虚逐实”，明显地有修饰的这种感觉。

下面咱们也解读一下：

“微数之脉，慎不可灸”，就是如果患者的脉象呈现于微而且数的情况，不可轻易地使用火攻的方法治疗。微脉，在这个地方应该候的就是津虚血少；数脉，候的是人体有热。这个地方要论述的是津血不足又有热的这么一种病理状态。可是这个地方客观地来看，仅仅是微数脉的话，有时候也不一定就是这种情况，有时候有一些重症里虚寒证也可能会出现这种脉又微又数的这种情况，尽管不多吧，但是这也有可能的。

这个“慎不可灸”，这个灸法，实际上也是一种用火加热的一种方法，比较适合于那种虚寒证，而不适合于这种热证。所以说“微数之脉、慎不可灸”。就是津虚血少，又有虚热的这种，也不能用灸的办法。

条文后边的这些文字内容，论述了对这一类的患者，如果施了灸法之后，从医理方面和病理变化方面对人体所造成的这种危害。按我们今天的理解，就说灸法会加重里热的程度，从而加剧津血的虚损；这个灸虽然不像火攻那么重，它刺激的是人体的一些重要的部位，或是某经络或是某穴位，所以对人体的影响反而很强烈，会严重影响人体津血的正常恢复，对今后的恢复都会影响比较大。

旁注“追虚追实”也好，“追虚逐实”也好，既可以加重津液虚损的这种证，又能加重里热证。这个“焦骨伤筋”，就理解成这是一种形容，就说危害比较重。因为这儿没有具体的症状。

下面做个小结：当患者呈现微数的脉象时，不可使用灸法治疗，因为灸法属于热性的治疗方法，可使人烦逆，还会加重津血的虚损。灸法看似火力微小，但是对人体的影响却很大，对人体津液和血液的正常恢复会造成严重的不利影响。

下边是第 116 条的第二部分：

“脉浮宜以汗解、用火灸之、邪无从出、因火而盛、病从腰以下、必重而痹、欲自解者、火逆之也•必当先烦、乃有汗而解、（注）何以知之•脉浮•知汗出解•（116）”

下面有个附注，“何以知之、脉浮、知汗出解”。这个条文和《宋本》比较一下的话，“火逆之也”在《宋本》是“名曰火逆”。这个“脉浮、知汗出解”，在《宋本》是“脉浮、故知汗出解”。

下边，我们也简单的解读一下：

“脉浮宜以汗解用火灸之、邪无从出、因火而盛”，就是太阳病不可用火灸的方法治疗。那么“脉浮”在这儿，理解成太阳病的一个简述，依法本来就应该“宜以汗解”嘛，如果说用火灸的方法治疗的话，起不到发汗解表的功能，不一定不出汗，但是没有解表的功能。就跟我曾经举过这个例子，感冒了以后打一场篮球，你跑一身汗，感冒也好不了，说不定还会加重呢，所以说发汗药最终的目的，是要愈病，出汗只是这个药起到作用的一个标志。那么，这个灸法不管有没有汗出，它起不到解表的作用，所以这儿说呢，就是“邪无从出”，就说病好不了。但是火灸的这个热呢，反而能加重疾病，也就是这儿所说的“因火而盛”。

“病从腰以下必重而痹”，这儿应该是作者的临床经验。那么对于表证，你要是如果说用灸法治的话就可能出现这种情况。但是奇怪

的是腰以下重而痹，就说下半身反应得比较明显，上半身相对会轻一些。

可有一个事儿，特别是夏天啊，你活动活动，汗呐正使劲儿出呢，这时候你突然用风扇或者凉毛巾或者空调一吹，体表一凉，汗毛孔就都关闭了，这好多水分就出不来了。它已经到了体表，特别是汗里边带着代谢的一些废物，它不能回到肾脏里边去，通过小便排出去，这时候就会停在体表。体表就会感觉沉、痛，这就是痹症的由来。所以治痹症，常常用到白术，其他的利尿药起不到这个作用，这也挺怪啊。但是这个机理肯定是这样的。

那么这个地方实际上说的就是这一类的情况。那个灸了以后，人体有一种出汗的机制，或出不透，或没有出来，但是水停在了体表，停在体表感觉到重，又重又疼。可是这一类的情况，是不是真正就是下半身时候特别重呢，我们现在这个在临床当中这种体验就比较少。我们就做个参考。

“欲自解者，必当先烦，烦乃有汗而解”，就说此类的情况，如果能够自愈的话，就会出现“烦”的这种瞑眩状态，然后才会有汗出，最后疾病解除。最后还是要通过出汗的方式，把这些废水废物排出来。

条文最后的附注，“何以知之？脉浮，知汗出解”。可以说它毫无实际意义。本身就是表证，表证本来应该用汗解的。

下边对这个条文做个小结：脉浮者，宜用发汗的方式来进行治疗。如果误用灸法，不但不会汗出而愈，而且火灸还可能致使患者从腰以下重而痹的症状反应，此类情况如果自愈的话，则可能出现烦的症状，而后才汗出而解。

烧针令其汗、针处被寒、核起而赤者、必发奔豚、气从小

腹上冲心者·**灸其核上各一壮、与桂枝加桂汤、**（注）更加桂枝二两也·**本**

云桂枝汤·今加桂五两·所以加桂者·以能泄奔豚气也·① ②（117）

注：

1. 《宋本》此条文如下：

烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚。气从少腹上冲心者，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤，更加桂二两也。

2. 《宋本》此处有桂枝加桂汤方及方后注如下：

桂枝五两，去皮 芍药三两 生姜三两，切 甘草二两，炙 大枣十二枚，擘

右五味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。本云桂枝汤，今加桂满五两，所以加桂者，以能泄奔豚气也。

胡希恕：烧针令其汗，这是从表证说的。针处被寒，这个针处被寒是什么意思呢，它不是针处被风寒了，这就是感染，拿到现在的话说就是感染。核起而赤者，这个被针灸的地方肿了，核起，肿的意思，其肿如核，色为赤。那么这个必发奔豚，这个奔豚呢。通常地讲，这个奔豚就是剧烈的一个气上冲，在《金匱要略》这样讲：“气从少腹，上冲胸咽，发作欲死，复还止。”发作的时候人受不了，但是过去了就好了。这个病叫奔豚。这就是一个神经症状，气上冲，病人感觉气上冲，那也是个神经，我们头前讲的气上冲也是指这个，感觉有气上冲，其实就是一个自觉的一种神经为上走性的这么一种证候。

这怎么必发奔豚呢，这就得根据《金匱要略》奔豚那一章了。奔豚那一章说的奔豚病呀，皆从惊恐得之。这个惊恐得之，并不是指外来的可惊可恐的事刺激发作奔豚，这个不是，这个就是在机体的身上，它有这个惊恐证候的基础上，那根据这一段最好讲。这个用烧针还使大汗出，这个人神经受剧烈的刺激，要发惊，发惊狂。那先头说的，加温针必惊狂，后面还有一段，它说亡阳，必惊狂，大汗出，这个烧针呢就是一个发惊那么假如说表未解有气上冲，上面汗出得多，气上冲也剧烈，那么在惊恐的基础上，尤其是在针处被寒，核起而赤，这又给病人一个严重的刺激，再有气上冲必发奔豚。那么就在这个惊恐

的基础上，这个神经症状再高涨，就容易发生奔豚。这一段说明，烧针令其汗，所谓亡阳，上面那个出汗太多，这个气，趁上也虚，底下这个水 and 气都往上冲，如果再针处被寒，给神经更为严重的刺激，那么一定更是因惊而发生奔豚证。那奔豚证是什么样的呢，气从少腹，上冲心者，就是这个。感觉有气呀从少腹上冲胸心，这个我在临床上遇到好象两次吧，不多，但也有的。而且这个方子也相当好。“灸其核上各一壮”，就是治这个感染，治针处感染，那一块红肿的，灸之。“与桂枝加桂汤”来治奔豚。

我们由这一段上，可以知道桂枝是治气上冲的。桂枝汤的原方加桂枝，就治气上冲了。所以桂枝治气上冲在这一条里头看得是非常清楚了。“更加桂二两也”，就是原方它是三两桂枝，更加桂，再加二两。也有人解释，这个桂是肉桂，这是错的。这个我用过，我知道。这个还是桂枝汤原方再加二两桂枝，现在就是十五克了。赵绍琴遇到过这个问题，他问过我，我说用用这个，他用过后就好了。他这个呢，桂枝汤的原方他就是桂枝汤的。桂枝汤也治气上冲呀，头前有“太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤”。桂枝汤也治气上冲，这个气上冲达到一定高度，就是奔豚。达到一定程度的高度，所以感觉“气从少腹，上冲胸咽，发作欲死”，到那个情形。它还是个桂枝证，另外还有脉浮，还有发烧，还有恶寒，桂枝汤的……所以用桂枝汤原方加桂。如果没有桂枝证呢，象头前讲的苓桂枣甘汤的脐下悸，那个是以水为主了，这个是以气为主。这个气也不是呼吸的气，是一种感觉，感觉有气上冲。这就是桂枝汤原方，把桂枝原先三两变成五两。

李冠杰：“烧针令其汗、针处被寒、核起而赤者、必发奔豚”；旁注“气从小腹上冲心者”；下边是原文，“灸其核上各一壮、与桂枝加桂汤”，这应该是个“灸”字，“灸”到了宋本就改成了“炙”字，很可能这个“灸”字是在抄写过程中抄错了。下边是附注内容“更加桂二两也，本云桂枝汤，今加桂五两，所以加桂者，以能泄奔豚气

也”。《康平本》里这个主要的条文是顶格的条文，在宋本里到了“更加桂二两也”这地方就止住了，后边加上了桂枝加桂汤的方剂和方后注解，那个“本云桂枝汤”以后的这些内容附到了方后注解里。这个区别非常明显，要如果仔细品的话也能给我们带来很多信息，因为《康平本》比《宋本》要早一些，在《康平本》那个时候还非常讲究“精”——少用文字，惜墨如金，所以说这个方剂呢就在条文后面加了桂枝汤又加了二两桂枝，就用这种方式说明白了，其它的包括方剂、方后注都省略掉了。到了《宋本》的时候又给它加上，这本身也应该说是一个进步的表现。从这种情况看，这两个版本只有《宋本》是在《康平本》的基础上改写而成的这种可能性，而没有人能把《宋本》的这个方剂给去掉，然后再把方后注的一部分提到上边，接到那个地方去，根本没有人会做这种事。所以只要是对的东西它到处都能验证，你越看越觉得《康平本》的真实性不容怀疑，而且《康平本》就是我们目前所见到最早的版本，是最接近于《伤寒论》本来面目的一个版本，所以我们这一次学习特别把《康平本》纳入进来。

下边解读一下原文：

“烧针令其汗”，是用烧针的方法来取汗的这么一种治疗方法。烧针正规的解释又名“火针”、“燔针”，它是以烧红针尖迅速地刺入穴位，旋即拔出，然后再以手按压针孔，以此为散寒取汗的一种比较古老的治疗方法。它原本是用来治疗痹症，或者是为痈疽排脓一种治疗方法。你看这儿，烧针来取汗，往往会有一些意想不到的不良后果。

“针处被寒、核起而赤”，原文的本意是有寒气随针孔流入、入留之意。今天看这是古人限于当时的技术水平，对这一类疾病的认识停留在那么一个层面上。今天解读的话，大家想想把针烧红了，再扎到肉里去，马上拔出来，等于是轻度的、面积比较小的烧伤的一个过程，所以很容易感染，这儿叙述的就是针处被感染以后的一种情况。

“核起而赤”按今天说就是红肿发炎了。

“必发奔豚”，就是说上边用这种方法治疗表证，就容易发生奔豚病这一类的。奔豚我们前边已经说过了，是《金匱要略》里的一个病症。这儿我们需要说一下这个“必”字，在《伤寒论》里多处用到，而且有好多地方是比较关键的，我特意查了词典，词典上“必”字一般的意思就是“必定、必然”，但是它还有另一个意思就是“假如、假设”。根据这个意思再延伸，像“如果、可能”，都是在古代的时候曾经用它来表达这类的意思。再来看看条文中好多用到“必”的地方，你就会觉得比较容易理解了，特别是像葛根汤那个条文——“太阳阳明合病、必自下利者”，它后边的条文又来了一个不下利的——“不下利而呕者”，这个地方如果把“必”字理解成“假设、假如、如果”就顺理成章了，所以说这个字儿在《伤寒论》里某些情况下应该这样来解读。因为这样解读客观，有一些条文要是把它理解成“必然”，就解读不过去了，确实有矛盾。这么解读，其实这也是“必”字的意思之一，并不是牵强的解释。从条文的治疗方剂我们可知道，条文所论述的奔豚病，它应该是在表证的情况下，以烧针强行发汗而发生的气上冲特别严重的一种病理。

前面学习第 15 条“太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤”，“其气上冲者”实际上就是太阳病吃了泻下药以后，它还有其气自表、自下往上冲的一种反应，这个时候要用桂枝汤来治疗。这个方剂就是桂枝汤加了桂枝，实际上与本条是一种情况，本条的情况是没有经过泻下而是用了烧针。大家想想烧针这种情形就行，病人躺着或坐着，医者拿针在火上烧的通红，“噌”的一下插在病人的肉里边，一般的人肯定精神会非常紧张的，对精神的刺激非常大，但是它又没有经过泻下，这个时候没有里的情况，所以这个气上冲的情况就会比较严重，假设患者胆儿又小，精神又容易受到刺激，就会表现出这儿说的奔豚证。桂枝加桂汤所治的奔豚跟《金匱要略》里的奔豚病有着质的区别，

这两个方剂从药物组成上看差别很大，实际上症状反应也差别很大，但是有一点是一样的，都是感觉有气从小肚子往上上逆，而且这个上逆得很奇特，上冲拱得人难受，严重的时候它不是特别均匀的上冲，像小猪在跑，所以叫“奔豚”病嘛！它们在这方面有一个共同的症状，所以把它叫做奔豚病。实际上这是两种病，它和奔豚汤所治的奔豚证里边差别很大。前边学习的时候，我曾经说过电视上报道过一个奔豚证，那人真是烦，《金匱要略》里说是“烦躁欲死”，他把家里的凳子往自己头上砸，“咣当、咣当”的，在床上把脚放到墙上去，难受到那种程度。大家想想，那种病桂枝加桂汤是治不了的，不是同一种病啊。

“灸其核上各一壮”，就是把那个“核起而赤”的地方灸上一壮。“壮”是艾炷灸中的一个计量单位，每一个艾炷称作是“一壮”，要是细分，“壮”也有大、小之分。灸感染的地方实际是一种辅助的治疗方法，用提高它温度的办法来加快血液的循环，促进感染的地方痊愈，没有什么特别的作用。对于上边这种情况条文里说的“与桂枝加桂汤”，这儿应该还有变通的余地。

这个方证的病理就是阳性表虚证兼气逆证，我们可以把它也归到气证里边。

做个小结：用火针的办法强行发汗，而且针处被感染，红肿发炎，假如造成患者发生奔豚病，表现为“气从小腹上冲心”等症状时，可先在被感染处各灸一壮，并用桂枝加桂汤予以治疗。

下边看看桂枝加桂汤的方剂组成，看能从中得到一点什么启示：

这个方剂就是在桂枝汤的基础上将桂枝这味药增加了二两，总共用了五两，其它的像芍药、生姜还是三两，甘草还是二两，大枣十二枚还保持不变。对于桂枝汤加桂这个道理，条文里注解说的也非常清楚：桂枝有降气冲的功能。这个桂枝治的气冲，是人体有从表解除疾病的趋势而形成的一种气冲，而不是其它的比如像肚子里有气往上来

那种，有一些属于肠胃里疾病的，恐怕治疗效果不会好，得符合这个方证才行。

拿这个方剂跟桂枝汤比较一下，就能发现经方用药之严谨，太严谨了！这个方剂的组成药物和桂枝汤是完全相同的，除了桂枝多二两以外，其它的药味用量也都一样。用桂枝加桂汤治桂枝汤证行不行？严格的不能说它不行，但是疗效绝对不会有桂枝汤好。如果不存在这个差异的话，桂枝汤就没有存在的必要了，把桂枝加桂汤说成是桂枝汤就成了，有这样的奔豚证可以用它治，没有也可以用它来治疗桂枝汤证不就完了嘛！为什么要设两个方子啊？再进一步分析的话，问题就显得比较尖锐了：方剂中就这一味药加了量，其它的都不变，但是这个方剂的功能就发生了很大的变化，甚至说它几乎发生了质的变化，它治这一类情况的奔豚病，如果使用桂枝汤来治恐怕就不行，这就可见经方用药的严谨！但是大家还不能仅停留在“经方用药非常严谨，我们临床当中千万不要动它的剂量，原方原量什么都不要动”这个层面，也不一定，应该灵活的去看，其它条文里已经给我们做出了一些示范，具体的后边再加以讨论，因为这个比较重要，涉及到临床的好多问题，咱们先把桂枝加桂汤的内容学完。

这个方证临床统计资料统计到了 34 个医案：

症状：逆气上冲 28 例，腹冷痛 14 例，呕逆 11 例，腹有包块 10 例，心烦 5 例。

舌质：以淡舌为主（有统计资料的病例是 10 例），淡舌 7 例，胖嫩舌 2 例，淡红舌 1 例。

舌苔：有记录的是 12 例，主要的是白苔、滑苔和嫩苔。

脉象：有脉象记录的是 18 例，弦脉 14 例，沉脉 8 例，细脉 5 例。

现代应用：神经官能症、植物神经功能紊乱、神经衰弱、心动过速、冠心病、风心病、结肠过敏、慢性肾炎、膈肌痉挛、某些心脏病、硬皮症、雷诺氏症、冻疮；另外还有的统计资料上写的比较笼统，像

外感、头痛、头晕、耳鸣。这是桂枝加桂汤的一些相关的资料。

桂枝加桂汤是一个比较典型的方剂，典型不是说它常用，而是它的药物组成和桂枝汤就差了二两的桂枝，而且方剂的主治又相差这么远，所以我们应该在这儿深入的探讨一下。

现在先提出一个问题来：大家都是经方爱好者，来学经方的，我们为什么学习经方？这个几乎每个人心里都很清楚，但是如果从方剂方面，脍炙人口的两句话就是经方组方严谨、疗效卓著；如果我们眼界再宽一点，时方中某些典型方剂的疗效也完全可以跟经方相媲美，这儿为什么要强调一些典型的方剂呢？非常简单，因为不是所有的时方都有这样的疗效。从总体来看，时方的疗效绝对与经方相差甚远，这个毫无争议。经方里用的药时方里全都有，但是为什么就没有经方疗效好呢？咱这指总体上，其它的因素，像个人使用方面都排除去，总体来看经方的疗效要好很多。那么时方差在哪？这个大家一定要弄清楚，如果不弄清楚就很容易走偏了。我跟大家做个提示，去查一查方剂的药典，比如《中医方剂大全》这本书，里边搜集了一万五千八百多个方子，其中凡是经方的方子基本上都有明确的方剂适应证，好多时方没有方剂的适应证，比如说这方子就治疗阴虚，换句话说就给了一个病理的概念，想辨到具体方证的话，还得再去了解药。咱们回过头来再说一说对药的理解到底是个什么情况？我们先回答一个问题，为什么时方的总体疗效不如经方，实际上就是时方在组方的过程中，有一部分主观臆想的东西占的成份比经方要大。我不是凭空说的，咱们一点一点剖析都出来了。现在临床中，大部分用时方基本上是以一个方子为基础，然后根据症状去加减。这里边就有一个加减的问题，实际上时方最初慢慢定型的时候，也是按照这种思路形成的，有人说“世上本无方，用的人多了成了形，它可能就成了方了”，这话说的非常对！咱们剖析一下方剂加减的实质是什么？有一个前提是我们不能回避的——为什么会出现经方和时方之间的疗效会差这么大？这

里就有一个问题，说目前人类对中药的了解非常初步、初级的，很粗浅，这个大家可能会觉得很奇怪，中药用了几千年了，人类对药性的认识像你说的这么肤浅吗？我们可以从另一个角度说，任何一味中药的治疗机理现代医学都不知道，它对所有中药的治疗机理都不真正清楚，包括现代医学对中药的一些研究，你仔细分析它好多都不靠谱。甚至研究出来说柴胡还有某些消炎作用，是看它治的这些病得出的，要真拿它来消炎的话，如果没有柴胡证，它消不了炎，解决不了这个问题，得有它那个证的时候才行。它怎么跟证对应起来的？实际上现在谁都解释不了。但是我们中医经过若干代经验的积累，对中药的了解，应该说相对的比现代医学要深入多了，但是还不足以用单味的中药自己去组方，到不了那种程度。咱们说一味具体的药，比如甘草就是很常用的一味药，特别是在时方里，几乎用时方的人都有个习惯，每付药里都要加上甘草，因为有人说甘草调和诸药（待会咱再说调和诸药）。你如果有兴趣，可以去搜集关于甘草的所有资料，不管是专业的论文，还是各个药典，对甘草说的也不完全一样，把它都凑到一块，你会发现甚至对甘草的寒热属性说法都不一样：有的说偏寒，有的说偏热，有的说没有明显的寒热倾向；甘草的功能解释的很多，如果单纯的看药的解释，你会感觉到热血沸腾：“哎呀！这个药可以治这么多病，真没想到”。但是要把它跟经方一结合，你会发现很片面、不全面。就说“调和诸药”吧，这是时方解释甘草用的最多的一句话。调和诸药的问题，我们拿黄芪桂枝五物汤来看看，实际上它是桂枝加黄芪汤把甘草去掉了，难道这五味药就不需要甘草来调和了吗？去掉甘草的作用是什么？甘草在这里碍了什么事了？恐怕这一点目前没有人真正能说到点子上。再反过来再解释：黄芪桂枝五物汤和桂枝加黄芪汤就差了一味甘草，两个方剂不同的地方是不是甘草证？这不能确定了。这仅仅说的是浅而易见的一个方子，如果深入的去分析，再加上涉及了其它的药，这是很多很多的问题，根本就解答不了的。在

这样的情况下，我们对中药的了解竟是浅到这种程度，如果自己组方，去跟人类几百上千年经过很多人体试验总结出来的方子相比，无论如何等于说走了一条弯路。一个人这一辈子能有多长时间啊？尤其是现在不能搞人体试验了，如果想通过自己的临床实践再去慢慢的积累方子，那路不就走远了嘛。经方都是经过了若干年、若干代的长期的试验，虽然经方的书籍里绝少来讨论某一味中药的，不给你解释，但它都是让你自己去体悟；不光这一方面，包括病理方面也这样。桂枝加桂汤里就说桂枝可以降冲气，但这不是原文，是后人加的注解，这儿就能品出好多东西来。但是经方对方剂的适应证却研究、把握得非常准确，咱们现在学的不都是方剂的适应证嘛！所以我们站在这个意义上，经方方剂是尽量不去加减。但是条文里也给我们做了加减的示范，非常的充分，像桂枝去芍药汤、桂枝加芍药汤等等很多，桂枝加桂汤不也是明显的加了药量嘛，也有很多这样的例子。可是这个例子给我们的启示看你怎么解读，我常跟大家说“经方不能轻易的加减，但是经方又不能不加减，应该在经方理论的指导下进行加减”。只要是在经方理论的指导下，像药味之间的变化、药味之间的比例变化（桂枝加桂汤就是），都完全可以加减。但是我在临床中，鉴于刚才咱们分析，药味加减实际上常常带有主观性，你感觉加上这味药是办这个事的，往往它实际上不一定，因为我们对中药的了解比较少。如果合方的话，把握就显得准确率比较高。

这儿我再跟大家说一个医案：我这有一个病人，上了年纪的老头，前边因为他说腿抽筋、两腿无力，明显就是芍药甘草汤证，我给了点芍药甘草汤，他吃了以后跟我说：这个药管事，但是吃了我大便有点稀，后来就不吃了。后来因为他有别的病要治，就把这个事忽视了。大概半个月以前，见他已经穿上棉鞋了，我就顺便问他怎么穿棉鞋了呢？他说现在觉得脚老是怕冷，就先穿上棉鞋了。我说你还抽筋吗？他说抽啊。这样我就想了一下啊，他抽筋是芍药甘草汤证，加上他年龄、

体质，陷入阴证了，而且他说吃了芍药甘草汤以后腹泻、里寒，这样我就把芍药甘草汤合上了四逆汤。可以从好几种角度去看这个方剂，你可以认为是四逆汤加芍药，也可以认为是芍药甘草附子汤加干姜，但是我在病例里写的是芍药甘草汤合四逆汤，它可以有芍药甘草汤的所有症状，也可以有四逆汤的所有症状。这个药给他以后，过了三天吧，我又碰见了问他有效果吗？他说因为时间有限，一天只吃一次，而且量也不大，但是有效，我觉得脚热了，不穿棉鞋了，而且抽筋也轻了。这就是说经方不是不能动，但是你一定在掌握了经方理论的基础上去动，人没有按照书本得病的，变通的对，疗效就非常好，一样还是经方的疗效。但是要变通的不对了，如果按照时方的思路去加减的话，也不是不行，但是病人好得就慢啦。咱们刚才已经把这个事都分析了。

火逆下之、因烧针烦躁^①者、桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之、

（118）

注：“燥”《宋本》作“躁”。

桂枝一两去皮 甘草二两炙 牡蛎二两熬 龙骨二两

右四味、以水五升、煮取二升半、去滓温服、八合、日三服、

胡希恕：火逆，就指头前那个“病从腰以下必重而痹”，这个病就叫火逆。这个火逆呀，跟头前说，解之当汗出，哦不不，是欲自愈者它一定汗出。还脉浮呀，还是病在外，所以这个火逆病，还是应该解表不应该下，所以下之属逆治，更不能烧针。下之，又用烧针，这个人反而烦躁。他起先不烦的，就是腰重而痹，那么这时这个人为什么烦躁呢？烦躁就是胃气不安那种情况。他还是表不解啊，它还是用桂枝，桂枝甘草汤加上龙骨牡蛎。这个桂枝汤的变化，在这个书里

头呀主要有三个变化：一个是桂枝去芍药，一个是桂枝甘草，一个是桂枝汤。也起桂枝汤的作用，但是解表作用不如原桂枝汤，但是也身疼，也解表，也是辛甘合用，桂枝辛甘草甘，龙骨牡蛎就不用解释了。它就是这个狂、恐惧、精神失常、心腹动悸，龙骨牡蛎都好使，神经官能这方面的都好使。就是桂枝甘草汤证而现烦躁不安的，或者如狂等，加上龙骨牡蛎。

这一段呀，火逆下之，根据头前，也有把火逆单独说是因火而逆之病，这是错的。要不它哪来的表证呢。它就是根据那一个，脉浮本应汗解，用火者它不出汗，它的表还没解，因而造成表热不出而发生腰以下重而痹的火逆证，它是根据这个来的。不是说另外因火逆之症下之用烧针，它一错再错。火逆就是因火而造成身重痹这一个病。可病还在表，又用下，又用烧针，一误再误，造成这个。这个桂枝甘草龙骨牡蛎汤，与我们上面讲的桂枝去芍药加蜀膝牡蛎龙骨汤差不多，上面那个呢解表的力量同是桂枝汤比桂枝汤稍有力一点。因为它那有姜，姜也是解表药。但这个方子桂枝用的相当少，你们看这方子，桂枝只有一两，说明这个表呀，它用下，这个表比较少了，那么只是烦躁不安表现突出，所以桂枝也少了，用得相当少。从我们临床上呢，如果表证还突出，气上冲还比较厉害，那桂枝可以多用，可以还搁三两。这几个方子，桂枝去芍药加龙骨牡蛎、桂枝甘草加龙骨牡蛎、桂枝汤加龙骨牡蛎，都是差不多。

李冠杰：这个条文在康平本里边也是一个顶格的条文。康平本里边的“燥”字是一个“火”字旁的“燥”，宋本里边是“足”字旁的一个“躁”，这应该宋本这个“躁”字是对的。

下边解读一下：

这个条文非常的简！它就说了一个症状，其余的全是病因。回顾第 116 条第二段有这么一个注解“名曰火逆”，但是这是一个旁注内容，原文没有这个意思。如果它这个“名曰火逆”注解对的话，就

成了这么一个问题了：这个地方说的“火逆下之”就是 116 条第二段论述的那种状态下，“再下之”所出现的情况。但是实际不是，经方里边应该说它没有一个明确的“火逆”的概念。就是说用火攻的办法来治疗表证是不行的，会出现若干的不良后果，这些所有的不良后果都应该是“因火而逆”，而不仅仅是指的第 116 条的第二段那种情况，所以说加“名曰火逆”这个注解就起到一个误导作用，容易误导人。“火逆下之、因烧针”，这个就是说的病因了。一般的理解，经方就是这么一个观点，对于太阳病如果误施以火攻的办法，他的病不好，又让他泻下，病还不愈，这个时候再加烧针，等于是一误再误。虽然说经方重病症不重病因，但是这儿强调了这么多的误治，他也有用意的，想说明这一类的方法对人体有比较大的影响，从方剂上来看，也能看出这人有虚的倾向，又因为烧针对人体精神方面影响比较大，形成了这个方证。“烦躁”就这么一个症状，但是咱们从临床统计资料看，这不是一个唯一的症状，还有其它的。这个需要咱们通过实践，通过对方剂的分析来拓宽它的方证的适应证。这个方证的病理就是阳性的表虚证合并了里虚证，伴有精神方面的疾病。

下边做个小结：误施火攻之法和下法之后，又加烧针致患者烦躁的，为桂枝甘草龙骨牡蛎汤主治之证。

这个方剂有四味药物组成，桂枝、甘草、牡蛎、龙骨，但是桂枝只有一两，甘草二两，你初看这个方剂好像就是桂枝甘草汤加了龙骨、牡蛎，但是这个桂枝用的量比较少，甘草用的量比较大，这就是说人体偏于虚了，甘草有补里虚的作用。如果从这个临床统计资料再全面地看一下，这个方剂的适应证基本上就是桂枝甘草汤证合并了精神方面的一些症状。从这个方剂当中我们可以看出，如果把统计资料里边这些跟桂枝甘草汤证有关的这些症状要如果说排除出去的话，剩下的基本上都是精神方面的疾病，那么龙骨和牡蛎的药物作用就比较明显了，它主要就是作用于精神方面的一些疾病。

下边看方证症状：症状上主要表现为——心悸、善惊、烦躁、失眠、汗出、气短乏力、神志异常。这个神志异常，不同的医者，记录的方式也不同，里边包括了神志呆滞，就是神志痴呆、表情淡漠、哭笑无常、昏蒙不知人事、发狂等。我想实际应该有一些出入，用这个方剂常会有加减的情况，所以这些症状里边我们也应该客观的看，也不是说所有这些症状都用这个方剂就简单的治了，不一定就是这样。

舌质：淡舌、胖舌、齿痕舌、绛舌、光舌。

舌苔：薄白苔、无苔，苔根发黄的。

脉象：细脉、弱脉、弦脉、数脉、沉脉、迟脉、洪脉、滑脉，这个脉象还是挺复杂的。

有治愈记录的这些现代疾病：癱瘓、更年期综合症、过敏性荨麻疹、遗精、精神分裂症、精神抑郁症、心动过缓、心动过速、心律不齐、心肌缺血、室性早搏。这些病里边有一个挺有意思：一个是心动过缓、一个是心动过速，这是两个虽然说都是循环系统心脏方面的疾病表现出来，但是它两个却是完全相反的两种症状——一个是跳得太快、一个是跳得太慢。我们应该怎么看统计资料？像这两个病应该说是反着的，但是为什么都能用这个方剂治疗呢？就是说这两个病人应该是在相同的病理，心跳得快它也可以治疗，心跳的慢它也可以治疗。所以说像这一类的理念，在其它的医学里边就感觉到很不可思议，特别是现代医学觉得不可理解：一个方证怎么会治这么相反的这么两个病？

大阳伤寒者、加温针必惊也、（119）

胡希恕：与 112 条那个一样，医以火迫劫之，亡阳必惊狂。伤寒脉浮表不解，和这个一样。就是无汗的伤寒的那种证候，就是太阳伤寒。这上如果要用温针，温针就是烧针，烧针迫使大汗出得厉害，汗

多就是亡阳，亡阳就是亡津液，那一定要发惊狂。这个惊狂，上次讲到两个意思，一个是多津液就多血液，血虚不能养心，心虚则惊。但是这里还不只是一个血液在心脏的问题，这是由于大汗出气上冲得厉害，气上冲表不解，这个冲气挟热影响脑系，这是为什么呢，回头看一看就知道了。你看太阳中风，用火针不惊狂。太阳中风它本来就津液虚，只能够造成焦枯伤津血气来复这种情况，它不造成惊狂。头前也有一条：太阳中风，以火劫发汗，就是 111 条，邪风被火热，血气流溢，失其常度。这个能致人死，最后说了，小便利者其人可治。原本小便不利津液虚到家了，这人有可能死亡的不能治疗了。前后观察起来呀，伤寒用温针亡阳而造成惊狂，心脏它不能说没影响，主要它是脑系，要是血液受伤之大而影响心脏，而太阳中风影响的更加厉害，你看太阳中风各节没有这个情况，都不说惊狂。所以只说太阳伤寒，因为太阳伤寒表实，实以虚治，用温针的治法，一方面使大汗亡阳，气上冲得厉害。所以容易使得这个头脑——总之这方面的问题多，与心脏也有关系，血脉通心嘛。血液虚影响心气。

这些节呀，给这个火攻作个总结。太阳病本来是依法当发汗，尤其是热病，古人对这个伤寒哪皆属热病。热病更不能用温针治疗，所以火攻根本就是错误的。头前的有的用灸，这都是火攻了，以火熨其背，以火熏之等。这都是造成火攻逆治的情况。到这里这个火攻就说完了。主要意思这些节，全是在太阳病这个热病，尤其是实证，虚证不可攻，实证更不可攻。所以表实证更不可攻。他为后头做了个铺垫。

李冠杰：本条文在《康平本》中为降一字格排版条文。

解读：“温针”：刺针入穴后，以艾绒裹于针柄点然加温留针的疗法，功能“温经通气”。本条文实际是对顶格条文的一个补充。因在其他条文中对火攻和烧针都做了详细的论述，这里特别补充，表证以温针治疗也属误治，当为作者的临床经验。

小结：太阳表实证，如果以温针的方法治疗则可能发生惊的病证。

大阳病、当恶寒发热、今自汗出、反不恶寒不发热^①、关上脉细数者、以医吐之过也、此为小逆。（120）

一二日吐之者、腹中饥口不能食、三四日吐之者、不喜糜粥、欲冷食、朝食夕吐、以医吐之所致也、（120）

注：《宋本》此两条为一条如下：

大阳病，当恶寒发热，今自汗出，反不恶寒发热，关上脉细数者，以医吐之过也。一二日吐之者，腹中饥，口不能食；三四日吐之者，不喜糜粥，欲食冷食，朝食暮吐。以医吐之所致也，此为小逆。

胡希恕：太阳病只能汗不可以吐下。这本书从侧面来说的情况相当多。太阳病，吐，也可造成很多问题，这个最常见是下面两条。太阳病，当恶寒发热，由于误用了吐药，虚其胃而邪陷于里，那么自汗出反不恶寒发热。阳明病的外证呀就是身热汗出不恶寒，反恶热。这个呢，自汗出不恶寒而发热，就是说有阳明病胃不和的现象。一般的阳明病都脉大。关上的部位呀候心下，候胃。它关上的脉细而数。细者虚，由于吐伤了胃气，所以细。但有热，未能从表解而陷于胃，有热所以数。这个清楚了，这不是真正的表证传里发生阳明病。要是真正的阳明病，关上的脉不会细数。细数者是胃气因吐而虚，同时有热，这是因吐之过了，这是当大夫在太阳病时误用吐药所致的情况。我们看看，如果要是吐的话，一二日吐之者，靠这一剂，刚吐完，这个人一定老是温温欲吐，这个胃气不下降反而上逆。他一吐后是有这个情景，他的胃气就要往上来。药力没过，一二日，它还是心里温温欲吐。由于吐而里边空虚胃中空虚，所以腹中饥，里边空虚，没有东西，都吐完了嘛，想吃但口不能吃，一吃就想吐。要是三四日吐之者，就时间久一点，久一点虽然没有温温欲吐之形，但是吃热的东西还不行。它胃不和呀还有热呀，不喜糜粥，热粥呀还不能吃，愿意吃冷东西。要是热的言外还是要吐。就是愿意吃冷食，它的胃气还是往上，没恢

复，也要朝食暮吐，早上吃进去，晚上还得往外吐，

胃气还是不纳。这是以医吐之所致也，不吐就不会形成这样了。此为小逆。这是太阳病吐之为逆。但是这个只是胃气微有不和，有虚热而已，为小逆，造成的问题不大，过两天可以好，吃点调胃承气汤也就行了。底下这个就不是了。

李冠杰：本条文在《康平本》中为顶格排版条文，且与下段同为第 120 条，“反不恶寒不发热”《宋本》作“反不恶寒发热”。

解读：“大阳病、当恶寒发热”，即太阳病正常反应。“今自汗出、反不恶寒不发热”，示意此非表虚证之汗出。“脉细数”，为太阳病经吐后所致的里虚热合并津液虚损的一种脉象。“自汗出”与“反不恶寒”也可佐证偏于里热证。“关上”，为旁注内容，意思是因有里虚则必应之于脉，原文并无必见此脉意，仅做参考。“以医吐之过也”，以上情况是由于他医吐法太过所致。“此为小逆”为旁注，可理解为此类误治对人体影响并不十分严重，在《宋本》将此注解移至下一段的末尾。本条文论述的是对太阳病误施吐法致人虚，因而脱离了表证阶段，并且有了轻微的里热趋向，但却没有发生明显的其他类型疾病的一种情况。

小结：太阳病本来应该恶寒发热，而刻下的患者虽有自汗出但是既不恶寒也不发热，而且脉细数的，是由于医者误施吐法太过所致。

第 120 条续：

一二日吐之者、腹中饥口不能食、三四日吐之者、不喜糜粥、欲冷食、朝食夕吐、以医吐之所致也、（120）

注：《宋本》此两条为一条如下：

大阳病，当恶寒发热，今自汗出，反不恶寒发热，关上脉细数者，以医吐之过也。一二日吐之者，腹中饥，口不能食；三四日吐之者，不喜糜粥，欲食冷食，朝食暮吐。以医吐之所致也，此为小逆。

解读：本条文为作者根据自己的临床经验而对上段条文所做的补

充，所论述的内容更为具体和量化。

小结：对于太阳病如果误施以吐法，一两天的时间，患者只是腹中饥，口不能食；如果持续三四天的话，则不喜糜粥，欲冷食，朝食夕吐，这都是医者误施吐法所致。

大阳病吐之、但大阳病当恶寒、今反不恶寒、不欲近衣、此为吐之内烦也、（121）

胡希恕：这个陷底下热比较严重。那么太阳病，宜发汗不宜吐，而医误吐者。太阳病在表哇，它应该发热同时恶寒，现在反不恶寒。所以这个太阳病一罢不恶寒，这个病全陷里了。而且这个病人不欲近衣，热得厉害，烦热得厉害，此为吐之内烦也。这全是因为吐，造成邪热陷入里而为内烦。这个内烦，不等于上面的小逆了，比那个厉害。这就说明，本来里边没有病，因为吃吐药，虚其胃气，外边的邪热趁胃虚而入于里了，入里就变成阳明病。

李冠杰：解读一下：

本条文论述的情况与第 120 条等一段的情况类似，都是太阳病吐后发生轻度里热证的情况。但是此处里热的程度要明显的严重些。

小结：太阳病本来应该恶寒，但是误施吐法后，反而不恶寒，而且不欲近衣，这是由于误吐后发生里热的反应。

第 122 条

病人脉数、数为热、当消谷引食、而反吐者、此以发汗、令阳气微、膈气虚、脉乃数也、数为客热、不能消谷、以胃中虚冷、故吐也、（122）

胡希恕：这个脉数，数主热，一般这个脉的证候是如此的。那么热能化食，当消谷引食呀，它里头有热，能吃。所以如中消症呀，就是里头热盛，能吃。但是这个不然，“而反吐者”，它不但不能吃东西，一吃就吐，这是什么原因呢，这底下就解释了。这是因为发汗发得太过，令阳气微，阳气虚于外，就是津液外虚，津液外微。而膈气里虚。膈气就是指胃气说的。那个津液哪来的呢，生于胃，化生于胃，胃为水谷之海嘛。由于发汗夺其外围的津液，发得太过，也影响胃气，所以夺其内气。这个数脉，也不光主热，也主虚，所以脉乃数也。数呢是客热。由于胃气虚，膈气虚，外邪趁膈气虚而动膈了。这句话很重要了：邪之所凑其气必虚。由于发汗太多，外边丧失的体液太多了，影响到膈气虚，就是胃气虚。外邪，邪热也趁胃虚而内入于胃。这个脉所以数，这个脉数是由于胃虚，邪热客之造成的。所以它不是胃里真有热，并不是胃气强，它并不能够消谷。“以胃中虚冷故吐也”，这是什么道理呢，就由于胃中虚，而寒饮乘之。这个胃中虚冷这句话呀这个冷当饮来看待。由于胃中虚，邪热往里跑，同时内饮也往里跑，所以胃虚再有饮，它非吐不可。所以“故吐也”。根据上面那个，它吃吐药……膈气虚，这时候呢客邪、水趁胃气虚而进入胃，也能造成人的吐证，主要的意思就在这儿。那么后边有这个例子，你象咱们讲的半夏泻心汤、甘草泻心汤都是由于胃气虚，不但邪热往那去，水饮也往那去，所以心下这个地方非常的硬，那就是人参证呀，所以这个时候都要用人参的。后边有，现在属于概论了，它没讲证治。这个虚冷呀，不是咱们讲的那个太阴病胃虚寒，它是胃虚寒饮乘之，所以说胃中虚冷，而致吐。

李冠杰：本条文在《康平本》中为降一字格排版条文。

解读：本条文所论述的是由于发汗太过而致里虚寒的情况，对于理解经方生理、病理、医理、和脉诊都有很重要的价值。“病人脉数”，即脉动次数较常脉为频数。“数为热”，一般情况下“数脉”候人体

有热。“当消谷引食，而反吐者”，在经方理论中，热象是一种机能偏于亢奋的疾病，所以常表现为食欲和食量增加，如果患者反而出现了呕吐的反应，其中必有原因。

“此以发汗、令阳气微、膈气虚、脉乃数也”，此处论述的是经方的生理和病理。“阳气”，在经方理论中常用来代表津液，“阳气微”即发汗太过而致津液虚损。“膈气虚”，即胃功能低下，亦为过汗所致。当胃功能不足时，人体的能量来源就会发生障碍，势必会影响到人体津液的恢复，为了维持人体正常的状态，循环系统就会以加快循环速度进行代偿，此即“脉乃数”的原因所在。“数为客热、不能消谷、以胃中虚冷、故吐也”，也是对生理和病理的诠释。“数为客热”，原意为此脉数为外热内侵所致，并非真正里热。

“客”为中医术语：①侵入人体的外邪，亦称客气。②侵犯、中。（如：风寒客于人。）③寄居、停留。（如：邪气入而不能客，故还于腑。）④形容后见于寸口的脉象。（如：先至为主，后至为客。）本条文则为第①种意思。

临床实践证明“数脉”不仅候热，也候虚证，这里正是此类情况。虽然脉现数象，但是为里虚有寒，而且虚证为主要矛盾，所以“客热”的论述有失准确。本条文实际就是论述的表证发汗后没有发展为里实热，却发展为里虚寒的一种情况，这里的脉数就是虚证的反应，并非热“客”于里。当然，这里并不排除寒热错杂的情况，如三个泻心汤就是典型的里虚寒而半表半里有热，但本条文看不出有任何热象的症状反应；再者，即使是有半表半里之热也不能称之为“客热”。由此可进一步明确对于脉诊的理解，一个独立的脉象在病理意义上与其他症状没有质的区别，不能单独用来作为确定疾病性质的依据。里虚寒自然“不能消谷”，对此作者也做了明确的解释“以胃中虚冷，故吐也”。

小结：患者表现为脉数，一般情况下数脉为有热，所以患者应该

消化亢进食欲增加，但是此患者反而出现呕吐的症状。这是由于发汗太过致使人体津液虚损，同时又发生了里虚寒证所致的脉数。数脉在这里候虚证，所以患者消化功能不会亢进，这是由于里虚有寒所致，呕吐也是因此而发生的。

大阳病、过经·十余日、心中温温欲吐、而胸中痛、大便反溏、腹微满、郁郁微烦、先此时、自极吐下者、与调胃承气汤、（注）若不尔者、不可与·○但欲呕·胸中痛·微溏者·此非柴胡汤证·以呕故知极吐也·①（123）

注：《宋本》此条文如下：

大阳病，过经十余日，心下温温欲吐、而胸中痛，大便反溏，腹微满，郁郁微烦，先此时自极吐下者，与调胃承气汤。若不尔者，不可与。但欲呕，胸中痛，微溏者，此非柴胡汤证，以呕故知极吐下也。调胃承气汤。

胡希恕：这个极吐下，就是大吐下，用猛峻的药吐、下的意思。由于这个病本来是太阳病，在十余日的时候病有陷于里之势，所以说过经，就是离开太阳病了，这个病由于极吐，吃了峻烈的吐药，所以心下老是温温欲吐，吐得厉害了胸中也疼，郁郁微烦，全是头前那个吃了吐药之后的那种情况，内烦哪。这个病一定入内了，这全是由于极吐所致。之所以温温欲吐，这个胃逆而不降。它不应该大便溏，所以搁个“大便反溏”；腹微满，这个大便溏的腹大概也不满嘛。要是腹微满，大便反溏，这是极下所致，就是吃了峻烈的下药而造成这种情况。一问病人，果然是“先此时自极吐下者”，在得这个病之前，病人自己极吐极下，就是吃了峻烈的吐下药，这个大概就是巴豆。巴豆这个药呀，又能使人吐又能使人下，而且吐下都是相当猛峻。如果这样的话，可与调胃承气汤。这个吐后，胃不和，大概都用调胃承气汤。为什么用调胃承气呢，本来吐后呀，胃气上逆得厉害，老温温欲

吐，吃了调胃承气汤就好。可是不要多吃，这也算是个定法了。一般这个吐下之后呀，全要吃调胃承气汤，才能纳食，要不然是不行的。如果“不尔者”，如果不是极吐下而成的上面那个证候呀，这可是柴胡证了，它应该过经了，它是由表传于半表半里的情况，那“不可与”调胃承气汤。就这节来看，“但欲呕、胸中痛、微溏者”，这都是柴胡证，为什么咱们不说是柴胡证而说“非柴胡证”呢，就有这一点。所以说临床辨证很重要。这个病人老是温温欲吐，柴胡证呢是心烦喜呕，它不是温温，这个温温，是愠愠，就是烦恼，难过得老想吐。小柴胡汤证没有这种情况。由于病人老有温温欲吐的情况，参考腹微满大便溏，所以才知是极吐下所致而不是柴胡汤证。一问果然，那就是与调胃承气汤。就是这个意思。所以临床问病呀得详细点。如果病人说唉呀我老要吐，又有胸中痛，这都是柴胡证，那马上用柴胡汤，那不对，得仔细。它这个心烦喜呕是柴胡证，喜呕就是好呕，呕得频繁的意思。那么它不是温温欲吐的情况。所以这个证候呀，古人的文字也有个障碍，咱们掌握得不好也不行。温温欲吐呀，烦恼得很，什么也不能吃，所以这个我们吃吐药，那是什么也不能吃就象头前讲的，“一二日吐之者，腹中饥，口不能食”，三四日好一点，但是也不能吃热东西，“欲吃冷食”，可是早上吃，晚上也会吐，它三四日，药力过去了点。吃吐药都有这个情况。怎样治疗呢，“与调胃承气汤”。调理这个胃气，胃逆而不下，调胃承气汤呢一方面去热，一方面使胃气不上逆。

李冠杰：“太阳病”，旁注“过经”，“心下温温欲吐、而胸中痛、大便反溏、腹微满、郁郁微烦、先此时、自极吐下者、与调胃承气汤”。后边有个嵌注“若不尔者、不可与”，这儿还有个缺字符号，“但欲呕，胸中痛，微溏者，此非柴胡汤证，以呕故知极吐也”。

这个条文也是一个顶格条文。

另外《宋本》嵌注“以呕故知极吐也”后面有“调胃承气汤”五

个字，《康本平》没有。

下面我们解读一下：

“太阳病、过经、十余日”，就是说患的这个病程比较长了。这儿加了旁注“过经”，这个旁注咱们不能把它放过去，实际上它对正确的理解原文，除了有误导作用以外，没有任何其他的意义。咱们先分析一下，他的意思就是说：太阳病因为病程比较长，已经离开了表证的病理阶段了，咱们可以这么理解。但是正文里面并没有这个意思。

下面的“心下愠愠欲吐”这实际上就是之前已经经过了“自极吐下”误治而造成的。用了比较猛烈的吐下药伤到了胃肠，所以感觉胃中“愠愠”总有想吐的感觉。这里的“极吐下”所用的药，从后面要以调胃承气汤去热的治疗方法看，应该是用的巴豆剂这一类的热性泄下药物，这也符合古代常用这类药物的习惯。因为是误治，所以既伤到了胃肠同时又产生了里热。

“而胸中痛”，根据药物治疗来看，就是吐的这个过程当中，或者食物上逆对胸部食道或器官刺激所致的这么一种“胸中痛”。

“大便反溏”，这是误施“极吐下”之后的一个余症，大便还表现为溏。这个“反”字暗示了什么？暗示患者有热证，如果有寒证这个大便溏是很正常的。这儿大便溏既有吐下的原因，而且又有热证，所以说用了一个“反”。

“腹微满”，应该是阳明的症状了，就是因为吐下太过了，致使胃肠里面发生里热，出现这么一种反应。

这个“极吐下”，恐怕巴豆剂在当时吐下的过程中应用率很高，应该是指的这一类的方剂。

“郁郁微烦”和“愠愠欲吐”有着密切的联系，有精神方面的一些因素，都是极吐下之后里热证的这么一种反应。

后面“先此时、自极吐下者”，就是来这儿治疗之前，他自己这儿也好，或者在他医那儿也好，用过“极吐下”的方法，造成胃不和。

包括病因、病症，综合考虑这就是调胃承气汤治疗的范畴。这里有“与调胃承气汤”，就是说有变通的余地。顶格条文就到此为止了。

下面嵌注内容，这个嵌注内容也值得我们深入地讨论一下。

“若不尔者、不可与”，上面正文讨论的这种情况，如果不是经过极吐下造成的话，可能属于别的病，不要用调胃承气汤来治。这里边暗含着有可能是柴胡证，大家看看这个症状就很明显了：一个是太阳病已经十多天了，具备了疾病发展为少阳病也好，阳明病也好，发展为其他疾病的这么一个条件；第二“心下愠愠欲吐、胸中痛、微烦”这些症状，都跟小柴胡汤证比较类似，如果不是经过吐下造成的这种情况的话，那么极可能是一个柴胡证。这儿在“不可与”之后有一个缺字符号，这个地方如果是个“之”字，就非常贴切了，就是“若不尔者、不可与之”。

后边“但欲呕、胸中痛、微溲者、此非柴胡证、以呕故知极吐也”，《宋本》有一个“下”字，“极吐下也”。意思就是说上边论述的这种情况，就是因为有“极吐下”的误治的因素在先，所以可以断定不是柴胡证。那么，如果说反过来呢，就证明前面“若不尔者、不可与之”，与什么啊？那不就是一个柴胡证嘛。要如果不是经过吐下造成的，那就应该是一个柴胡证。

这个论述上，论述得挺好，但是前前后后你得仔细看一看才能比较好理解。那么我们从这个地方可以得到一个启示：就是我们在临床诊断的过程当中，就应该全面。这个条文论述的这个事，是个非常简单的事。比如说病人来你这儿看病，你得问他，你吃着别的药了吗？是不是。在之前经过吐下之后的，就对前边这些症状起到了一个定性的作用，这是一个因素。所以四诊的过程当中，应该考虑得全面一些。这个条文，本身就重在辨证，当这个症状处于疑似之间的时候，就要注意病因等其他方面的一些因素，免得误诊了。

下边做个小结：

患太阳病已经十多天的时间，反而自行以极吐下的方法治疗，如果表现为心下温温欲吐，而胸中痛、大便反溏、腹微满、郁郁微烦的，应该用调胃承气汤类方剂治疗；如果未经吐下治疗的，则不可用此方。条文中论述的“但欲呕、胸中痛、微溏”等症状，不属于柴胡证的反应，而是由于误用“极吐下”的方法所致。

大阳病六七日、表证仍在、脉微而沉、反不结胸、其人发狂者、以热在下焦、小腹^①当硬满、小便自利者、下血乃愈、（注）所以然者·以大阳随症^②·瘀热在里故也·（经）抵当汤主之、（124）

注：

1. “小腹”《宋本》作“少腹”。
2. “以大阳随症”《宋本》作“以太阳随经”。

水蛭熬 虻虫去翅足熬 各三十个 桃仁二十个去皮尖 大黄二两^①酒洗

注：“大黄二两”《宋本》作“大黄三两”。

右四味、以水五升、煮取三升、去滓、温服一升、不下更服、

胡希恕：太阳病六七日，这是要传里了。四五日，它要传半表半里，六七日它要传里了。可这个时候呢表证还有，这个表证是指表热说的，还有外热。可是脉微而沉，表脉应该浮呀，脉微而沉者，沉为在里，微，血液有所阻碍，里有所结，结实很深了，所以脉沉微。里头实呢，它的脉沉，不会有微。脉微而沉，所以结的程度相当深了。后头有，结胸脉，结胸就是里实得很厉害的病了。结胸脉是寸脉促，关脉沉。那么这个结实如此之深，依法应该结胸，而反不结胸，它没

结在上头。“其人发狂者”，这个与头前讲的桃核承气汤都是瘀血证不一样，那个是如狂，这是发狂，比那个厉害，干脆就是发狂，就是现在精神病人样子了。这是什么道理呢，这不只是热结的问题，这是血结的问题了。“以热在下焦”，就是热和血结于下焦。结于下焦的部位呢，“少腹当硬满”，小肚子应该硬满，它结在那个地方了嘛。小腹硬满有两种情况，一种小便不利，影响到膀胱的蓄水，所以小腹硬满。如果是小便自利，那与水没关系，纯粹是血瘀的问题了，所以“下血乃愈”。这是“瘀热结于下”。“所以然者，以太阳随经，瘀热在里故也”这句话有问题了。古人看问题未必真。这个瘀血哪来的呀，古人认为下边的血受点邪热就结在那个地方，这是有问题的。这个瘀血证，我们在临床上的观察呀，大概总是这样的多，这个病人平时就有瘀血，旧有瘀血，在少腹的地方最多了，拿现在的话来说呢，就是静脉有所瘀滞。因人老是站着坐着，液体它往下，我们可以看看解剖生理学，在盆腔这个部位，膀胱、大肠这里有很多的静脉血管。打架呀怕伤小肚子，伤了就会出血不止。所以古人叫这个地方为血室，这是指男人，女人就是指子宫了。瘀血呀沉淀在少腹的情形最容易最多了。它平时就有，但是没有诱因它也不发作，偶尔赶上外感了，发生太阳病的时候要传里的时候，这才可能瘀血证发作起来，人就发狂，这时候用桃仁承气汤或者抵当汤，就得看情形了。如果是病比较重，瘀血难解，用抵当汤的机会多。如果这个人病不那么严重，象桃核承气汤，其人如狂，少腹急结，也不是硬满，这个少腹硬满，结的东西也坚固，那个急结而已。桃核承气汤，其人如狂，它有时还下血，这个绝不下血，所以这个瘀血证比较顽固，只是用桃核一味是不行了，所以它给水蛭虻虫。同时它也不用甘草，甘草这个药缓哪，它能缓药力。所以大黄芒硝泻得厉害，你加上甘草就叫调胃承气汤，你看它们两个挺厉害，加上甘草这个东西呀它能缓这个药力。想用大力的驱瘀下血，甘草它不合适，所以把甘草去掉。热不象桃核承气汤，所以芒

硝也去掉。搁水蛭虻虫桃仁大黄，水蛭虻虫这两个药，作用差不多，都是驱瘀之中兼有解凝的作用，所谓解凝就是解那个结实。它对这个能起作用。我们对它的医疗作用呢就是顽固陈久的瘀血，我们是要用水蛭虻虫的了。像干漆廔虫，都是这个作用，要比桃核、丹皮有力量。所以叫抵当汤，抵当汤的就是非它不足以抵当的意思，重一点的瘀血呀，得用这个来驱逐。

李冠杰：这条是顶格的条文。条文中的“小腹当硬满”在《宋本》里是“少腹当硬满”，这个没有原则的区别。嵌注里的“以太阳随症”，在《宋本》里给改作了“以太阳随经”，这个差别就很大了，咱们到学习的过程中再详细讨论。

下边解读一下：

“太阳病六七日、表证仍在”。就说患太阳病病程已经比较长了，虽然说表证仍在，暗示已经有发展为其它疾病的可能性。

再看看脉象——“脉微而沉”，明显已经不是表证的脉象了。我们还可以这么理解：上边说的“表证仍在”，只是有表证的某些症状，比如发热恶寒这类的，但是脉绝对已经不是表证的脉象了。

“反不结胸”，这个地方应该看作是作者教人以辨证的方法所举的一个例子。结胸证常表现为沉微的脉象，这儿说“反不结胸”，就说虽然有结胸的脉象，但是没有结胸的症状。那么“反不结胸”是怎么来的？因为没有结胸的症状，只是有结胸的脉象，这就示意人们应该把结胸证跟这个方证要加以区别。我们推而广之，古人说的东西，受当时书写条件的限制，它比较精简。如果举一反三的话，大家想一想，沉微的脉象，微而沉也好，这类的脉可不仅仅是结胸证和抵当汤证所特有，比如阴性证很容易出现，里虚寒证也很容易出现，停饮证也有可能出现这类的脉象。这个地方是以结胸证为例子，让你去重视辨证的道理。在这一条里，脉微应该是瘀血所致的血流不畅的一种征象；沉为在里，也就是里有瘀血。

“其人发狂”，是这个方证的一个特征性的症状反应，与桃核承气汤证的那个“如狂”属于相同类型的疾病和类似的疾病性质，但是程度不一样。

“以热在下焦”，是对抵挡汤证的一个病理解释，但是从治疗疾病来分析，这个方剂并不是只治下焦有热。这个“以热在下焦”有另一层意思，它呼应后边的“小腹当硬满”，有特意为它做一个说明的意思。因为待会看一看它所治疗的那些病的话，瘀血也不仅仅是下焦的问题。

“小腹当硬满”在临床当中，就是患者感觉自己的小肚子“胀满”，腹诊往往都是医者感觉有抵抗感，患者拒按，按了以后会不舒服，甚至疼痛。“小腹满”这个证，它可能是因为瘀血所致，也可能是因为停饮所致，所以说这儿就需要进一步地再辨证，到底是什么原因造成的？到底是什么样的病理形成的这种症状，是停饮还是瘀血呢？

下边有了——“小便自利者”。这儿还是辨证的精神，你看看他的小便怎么样？“小便自利”就把它理解成小便通畅或者小便正常，这样就可以进一步地排除“小腹硬满”是因为小便不利造成的，可以排除这个因素，余下的就是瘀血证了，所以说“下血乃愈”，而且要“以抵挡汤主之”。

这个条文在经方书里也可以堪称是一个典范的条文，它论述辨证精神、辨证方法可以说是一个典范。你看条文中列举了三个典型的症状：一个是“脉微而沉”，一个是“其人发狂”和“小腹当硬满”。如果我们看看其它的条文，这三个症状其实已经足够构成应用抵挡汤的指征了，真正要是停饮的话，人能发狂吗？所以说这个地方的病症比好多其它条文还多，还丰富。为什么作者在这儿不惜笔墨，同时又列举了一些“反不结胸”、“小便自利”一些旁证？目的就是要示人以辨证的方法，就是让你从中去体悟这些辨证的方法。

如果我们进一步讨论，在经方的临床应用当中，不同的方证之间

广泛的存在着症状反应上一些相互交错的现象，比如“麻黄汤证”和“桂枝汤证”，它们共同的症状是什么？“脉浮，头项强痛而恶寒”，这是比较典型的吧。不同的是什么？一个是脉浮紧，一个是脉浮缓；一个是有汗，一个是无汗；其它的基本上都是相同的。相同就是症状交错嘛。不仅表证之间存在这个问题，在其它的方证之间广泛的存在着这类的问题，像同一个症状，可能出现在若干个不同的方证之中，而同一个方证中，又可能同时存在着若干个其它方证中的症状。特别是我们现在，每一个方证都跟大家整理了一些统计资料，对照一下已经学过的方剂，它们之间相同的症状交错的非常多，实际上这就是经方辨证的难点之一。你说实际上它都是动态的，这还是一个，我们现在看的还是一个静态。还有另一个问题，每一个方证都不是一个固定的症状群。要再加上这些因素的话，辨证的过程就显得更乱了。其实只要是把握的准了，把握的到位，也不是说不可辨，不是特别难。咱们前边曾经说过的病理辨证体系，也就是“表、里、半表半里，水证、血证、气证，阴阳、寒热、虚实”，你把这些东西弄清了，在这些病理状态的指导下再去辨证，就会变得简单的很多。抓住一个证，然后再去找其他证，比如这个人老想干呕，想吐，如果这个人没有多么特严重的病，很明显的病症没有，首先想到的是“柴胡证”。再问有口苦吗？身上一阵冷一阵热吗？如果找了一大堆都没有，这个呕就跟柴胡证没关系了，不是少阳病。那么再去看看有肠鸣吗？如果肚子咕噜，大便不好，那么离半夏泻心汤证不远了，到底是不是呢？再去找其他的证。就是这样在病理辨证要素的指导下，然后再去确定具体的方证。

像这个方证中的“脉微而沉”，像里虚寒证、里实证有时候会出现这种脉象，停饮证、结胸证、瘀血证这类的病理状态都有可能出现这类的脉象。咱在这说的是一些病理状态，如果再具体到方剂，光这一个“脉微而沉”就有可能涉及到几十个方子。仅凭这一个脉象，绝对是没法断定这个疾病的性质的，更没法用药。但是如果这个脉象和

“其人发狂、小腹硬满”，再加上“小便自利”的话，如果同时出现，这一下范围就缩到很小了，差不多几乎就一两个方剂了，这就是胡老说的：“辨方证是经方辨证的尖端”。这也就是整个条文里边给我们展示的经方中对比、排除的方法，这是经方辨证的基本功之一，要练好这个基本功，必须得熟悉经方的理论，把经方的理论弄通了。

下边是嵌注：“所以然者，以太阳随症，瘀热在里故也”。这个嵌注内容也值得我们研究，它本身是对正文的一个解释。

“以太阳随症”应该理解为：虽然有“太阳病”的某些症状反应，但是已经不是疾病的主要矛盾了，我们现在就这么理解比较好。要如果把它改成“以太阳随经”，不是“随症”了，改成“随经”了，大家再看这一句话，那绝对就不是一个过经的问题了，这直接说的就是经络了。那么它本意就改成了经络发病已传变的这么一个意思了，跟经方理论就不相同了。大家可以去体悟，好多东西真正跟经方理论是相悖的。这个就生生给改了的，大家仔细看看吧。

“瘀热在里”就是对“以热在下焦”做了进一步的说明。像这个方证不仅仅是一个下焦的问题，还有热，但不一定仅仅是下焦有热。虽然说我们在临床当中接触到的大部分都是些所谓原发的疾病，就是个“瘀血证”，根本就没有表证这一说。但是这个条文论述的却是由太阳病发展而来的，它有太阳病不解的这么一个病因。这儿它有两层意思：一层意思是跟我们展示一个“抵挡汤证”完全有可能由太阳表证失治以后发展而来；另外一层意思就是说虽然这个方证它有里热，但是如果有瘀血，以“瘀血证”为主要矛盾的病理情况下，就不必要先去解表了，就直接攻里下瘀血就行了。这个就跟“桃核承气汤证”形成了一个对照：“桃核承气汤证”要先解表，这个不需要先解表。如果细分析的话，这里边就蕴含了经方理论对生理病理和医理的一些阐释。我们只要是提示到这儿，大家都能想到。这个条文，如果我们加上辨证方法这类的内容，条文虽然文字不多，但是它所蕴含的内容

非常的丰富。“抵挡汤证”的病理——“瘀血证”，我们把“瘀血证”放在前边，因为它瘀血是一个主要矛盾。“瘀血证”如果我们放在病理辨证体系中，血实证合并里实热证或伴有表证。

做个小结：患太阳病已六七天的时间了，表证仍然存在，但是却表现为“脉微而沉”，反而没有“结胸”的症状，同时表现为“其人发狂”的，是由于血瘀热结于下焦所致。此时小腹应当硬满，如果小便自利的话，说明不是停饮证所致，当使用攻下瘀血的方法即可治愈，此为“抵挡汤”主治之证。

这个方子由四味药组成：水蛭、虻虫、桃仁、大黄。方剂中有一个小差别，在《康平本》里大黄是二两，但在《宋本》里大黄是三两，知道有这么一个差别。水蛭和虻虫都是比较有力的祛瘀血的药：其中水蛭寒热倾向不明显，它是性平；虻虫属于寒性的一种下瘀血的药。这两味药如果又与桃仁（桃仁也是一个下瘀血的药）并用到一起，就形成了一个强有力的祛瘀血的药物组合。在这个基础上再加上大黄，大黄泄热导瘀，整个方剂就形成了一个能够攻下顽固性、陈旧瘀血这样一个特效方。关于水蛭和虻虫这个药性，我记得可能也跟大家讨论过，虻虫、水蛭都是动物，它们有一个共同的特点——就是说它们那个嘴啊都是吸盘，它们以吸食其它动物的血为生，吸盘吸在其它动物身上以后，那个血是吸不出来的，它要先往动物的体内注入它的唾液，它那个唾液对动物的血液有稀释作用，稀释以后它就能顺着动物的皮肤把血液吸出来。但是我们用水蛭，逮以后用热水把它烫死，然后再把它晒干了；虻虫就是我们常说的那个牛虻，这个牛虻得是雌性的，雄性的不吃血，它吃嫩树干或者嫩树枝的津液。它得是雌性的，而且得按照正规的加工方法，逮着以后把它拍死，之后用绳把它穿起来晾干。它都已经干了，已经没有那个唾液了，能吃多少？我们看看那个剂量：水蛭是 30 个，我称了称，包括大的、小的，均着称 30 个是 35 克左右，合汉代的大概也就是 2.2 两；虻虫也是 30 个，30 个虻虫一

共3克左右；桃仁20个，还得去皮尖，去完皮尖以后20个大概是6克左右；大黄它是个导瘀的药。就这些下瘀血的药，怎么用呢？大家去看看方后注就行了，它是熬汤喝啊，再放到水里去熬，水能溶解出多少东西来？它还不像后面那个抵挡丸，抵挡丸还要粉碎了以后还捣呢，这个连捣都不用捣。从这个地方，大家细想的话，里边事就挺多，你看它就这些有效的药，还得把它熬了，熬了以后它溶解到水里边一些有效物质，喝的时候还得去滓，不能把这些药喝进去，只喝它那个水分，大家想想如果把它那个水分（水肯定是不能治病的）给它烘干了，能剩下多少东西？但是看看里边东西能治什么？治的却是顽固性的瘀血——人疯了，治的却是大病。

现在我突然想到一个事，这段时间电视节目里几乎天天在报道老年痴呆症，在中国给它命个什么名字好？在征集它的名字。实际上很多那样的病，现代医学说它是不可逆的，大家看看它是什么症状：一个是精神失常，就不懂正常人的事了；另外一个就是记忆明显的下降。放到经方里不就是“喜忘”嘛！他精神失常但是还没有到了发狂的地步吧？实际上怎么叫不能治啊？这个事啊，从现代医学上看也挺悲哀，它并不是一个什么难治的病。

症状：少腹胀痛 32，发热 13，便秘 12，下腹部包块 12，烦躁 9，食欲不振 8，恶心呕吐 7，停经 7，畏寒 6，头晕 6，消瘦 5，头痛 5，神疲 5，发狂 5，胃脘胀满不适 4，皮肤瘀斑 4，半身不遂 5，小便短小（少）4，面色苍白 4，（可见条文中发狂和发黄都为特征性症状，但未必是常见证。）

舌质、舌苔：舌有瘀点瘀斑 4，舌红 7，舌紫暗 3，苔黄腻 4。

脉象：沉 17，涩 7，数 6，弦 5，滑 5，弱 2，微 2，细 2，伏 1，结 1，紧 1，实 1。

现代应用：血栓性静脉炎、脑血栓、多发性脑梗塞、脑血管意外、心肌梗死、动脉硬化、高血压、癫痫、癌病、反应性精神病、三叉神

经痛、精神分裂证、痫症、半身不遂、子宫内膜异位、急慢性肝炎、肝性血卟啉病、急慢性胆囊炎、肝昏迷、胰腺炎、月经不调、闭经、子宫肌瘤、急性盆腔炎、附件炎、胎盘滞留、痛经、卵巢囊肿、卵巢囊肿破裂、乳腺病、行经发热、产后感染、胎死腹中、结核性腹膜炎、伤寒、消化道出血、消化性溃疡、肠梗阻、机械性肠梗阻、慢性结肠炎、食道狭窄、老年消化道术后功能减退、急性坏死性肠炎、肠道寄生虫病、糖尿病、运动麻痹、冠心病、心绞痛、肺心病急性发作、特发性尿血、慢性肾盂肾炎、慢性肾功能衰竭、尿路结石、肾炎尿毒症、运动性血红蛋白尿、尿潴留、慢性前列腺炎、流行性出血热、外伤、骨质增生、风湿病、结核、五官疾病、皮肤病等。

我们看看症状里面，比如说像头疼、神疲，像头晕、消瘦，像这类的症状，尤其是头晕，停饮证也可能出现头晕嘛。那我们去体悟一下，如果辨证的过程当中要与停饮证区别开来，它说的是一个小便的问题，如果这个病人没有像小腹硬满这一类的，大家看一看在这个症状里边，他反倒是没有它，它不是一个典型的症状。假设这个病人主诉是一个头晕呢？你就得去找找有没有停饮证。我们换一个角度说，站到现在停饮证和瘀血证的角度上看，瘀血也可能造成头晕，停饮也可能造成头晕，有了头晕这一个症状，你认为它可能是瘀血，得去找瘀血的证据；你认为它是停饮，就去找停饮的证据，像小便利不利啊等等的；那头晕还有别的，如果你怀疑有别的方证的话，也得找别的方证。所以，这就启发我们临床当中思路要宽一些，不要以为抵挡汤条文里没有头晕这个症状，有头晕它就是水证，那么不一定，再去看看。如果换一个角度再说，如果确定了这个人基本上就是个瘀血证，我认为它是个抵挡汤证，准备给他用抵挡汤，但是它同时又有头晕，那就没有问题了，你不用再考虑它是别的事情了——或者说是少阳证、或者说是停饮证，你可以去找一找别的证据，如果说没有，这个头晕也是可以治的，没有问题。所以说这些资料都是可以说明问题的。

另外有一个需要说明的问题，因为这抵当汤和抵当丸的资料都是一个，所以说下一条里有一个“发黄”，在条文里面论述的发黄和那个发狂这一类的症状，它都是一些典型症状，但是在临床统计资料看未必是常见症，甚至可能出现的几率反倒很低。那么条文里为什么把出现几率这么低的症状拿过来，作为论述的重点呢？这么多症状为什么不去说别的？那就是因为像这一类的症状它有特征性，特别是那个“发黄”，你要看到“发黄”以后就会想到这个“黄疸”是不是茵陈蒿汤证啊？在条文里面特意把它论述上了，你就会想到这个是因为瘀血造成“发黄”的，在下一条里面我们马上要讨论。

治疗的现在疾病越多，实际上我们的思路越宽，你千万不要把它当做累赘。比如像现代疾病的脑血栓、心肌梗死、动脉血管硬化、高血压这一类的，可能你会觉得这个比较好理解，这个都跟循环系统有关系；像三叉神经痛这些神经系统病也好理解；还有一些像肝脏方面的病、胆囊方面的病、胰腺方面的病，像这一类的疾病，也有可能是因为瘀血造成的。所以这一类的统计东西，它只要是真实的，是越宽泛越好，可以帮助我们拓宽思路，这个呢大家可以在下面自己慢慢地看。

大阳病身黄、脉沉结、小腹硬^①、小便不利者·为无血也·小便自利、其人如狂者、血证谛也·抵当汤主之、（125）

注：“小腹硬”《宋本》作“少腹硬”。

胡希恕：那么这个辨的是血瘀水瘀之辨。太阳病身黄，这是黄疸证，有一种这个血瘀性黄疸，这在临床上也是遇得到的，你不去瘀血，这黄也是去不了的，它这个不是一般的黄疸。脉沉结，沉者为在里，结，就是结代的结，由于里有所阻碍，所以脉沉而结。少腹硬，跟我们前面的少腹硬满也是一样，就是里有所结了，在下面。“小便不利

者，为无血也”，如果小便不利，膀胱蓄水也会使得少腹硬，那你尽管利小便就行喽。小便自利，所以这个少腹硬有这么两种情况，瘀血症，轻者急结甚者硬满，这是瘀血病了，小便可自利。小便要是不利是水。所以这一段哪，是蓄水瘀血的辨证。如果小便自利，其人如狂，这个发狂，所以这个瘀血证呀，十有八九影响脑系。这在临床上要注意了，有很多特殊的头痛、癫狂、女性癫痫，属瘀血证的都不少，所以瘀血证最容易影响头脑。其人如狂，血证谛也，这是清清楚楚的是瘀血证。那它是要用抵当汤。这就是深入的来说明这个少腹硬满与蓄水鉴别的方法。这个很重要，要是蓄水证当瘀血证来治，那就坏了。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边是顶格的条文。“小腹硬”，在《宋本》为“少腹硬”，这个恐怕就是抄的问题，没有质的区别。

下面解读：“太阳病”，与上边的那一条相类似：一方面示意这个方证可以由太阳病发展而来；另一方面就是说在太阳病未解的情况下，而这儿没有涉及其它的问题，可以使用本方治疗。“发黄”，指的黄疸病。但是抵当汤证所治疗的黄疸，跟其它的黄疸病的病因不一样，这儿的黄疸是因为：一方面里有热；另一方面有瘀血，他的主要的成因就是因为瘀血造成血流不畅，致使那些因为里热而产生的代谢物，没法正常地排出体外所造成的。“脉沉结”，就是说既沉而又结的这种脉象，这个结脉是指的“脉来缓，而时有一止”，而且“止无定数”，不太规律，就是他本身这种脉象就是血流不畅的一个证候；“沉”为在里。“小腹硬”，跟上一条的“小腹当硬满”应该是相类似的症状，机理也相似，它的成因也是一样的——或停饮、或瘀血。

“小便自利，其人如狂”，前边已经讨论过了这样的辨证，只要是他存在小便利，那么他就是因为瘀血造成的，再加上“其人如狂”这个症状，完全可以断定他是瘀血造成的。“小便不利者，为无血”，后边还有一个“血证谛也”，你看这个旁注加的，应该说它对我们理解这个正文所展示的这个辨证方法，有一定的意义，可以帮助我们去

解读这个条文，应该说有一定的积极作用。

这个条文和上一条相对照，除了“发黄”这个症状以外，没有一个新的症状，基本上都相似，辨证思路也非常相同，也都是说要辨水证和血证之分，这个条文它真正的重点论述的应该是什么？是因瘀血证也可以造成黄疸病，这也是这个方剂治疗的一个范畴。

下面做个小结：太阳病同时又发生黄疸病，并且表现为“脉沉结、小腹硬、小便自利、其人如狂”的，为抵当汤主治之证。

伤寒有热、小腹满、应小便不利、今反利者、为有血也·当可下之、宜抵当丸、不可余药·①（126）

注：《宋本》此条文如下：

伤寒有热，少腹满，应小便不利，今反利者，为有血也，当下之，不可余药，宜抵当丸。

**水蛭二十个熬 虻虫二十个去翅足熬 桃仁二十五个去皮尖
大黄三两**

**右四味、捣分四丸、以水一升、煮一丸、取七合服之、
晷时当下血、若不下者更服·**

胡希恕：这个也很重要。伤寒有热，不是表不解而有热，有两个问题，以前咱们讲了，里有停水，表不解，心下有水气表不解。伤寒有热，你非利尿去水气，才能见效。那有瘀血的也影响热不解，它的道理是一样的，里有所结，它的里气不通畅，影响内外的条达。这是互相影响的。古人有句话的意思是：北边你不打开，南边的风就进不来。这个人体是个密闭的东西。它还里气不通呀，表气也闭上，所以发汗没用，伤寒有热，这不白搁了。后面还有一节，说是病发热，十余日，虽脉浮数者，可下之，有那么一条，咱们也讲完了，利用这个伤寒有热呀能体会到这个问题。虽脉浮数者可下之，它说病人就是发

热，虽然脉浮数，虽是表证者可以下。它假如说下后，脉数还不解，说明这个热还不退，那你要用抵当汤，那是瘀血。热得消谷善饥，这个瘀血呀瘀热，这个人也“嗜睡”，所以咱们治那个“嗜睡”证呀，有用抵当汤的机会。也有用那个桃核承气汤的机会。把这个搞清楚，在临床上才能够联想到一切，不然的话是不行的，这一段呀有这么个问题，所以表证不解，热不退，有蓄水和瘀血，有这么两种问题。蓄水就是小便不利，或者里面有停饮，这在头前讲很多了。这一段呢就是里头要是瘀血证，也有一样的情况，少腹满，影响小便不利。这个小肚子满，如果蓄水的话，应该小便不利，所以伤寒热不解。既然利了，那就不是有水的问题了，“为有血也”，为有血也影响伤寒有热而不解，它是这个意思。所以文字非常的简，你如果不注意还看不出来。“当下之，不可余药”。不可余药，大家的解释有些是一点药也不要剩，那是错的。不可用其他的药。它主要的问题是什么呢，就是伤寒有热。无汗伤寒而热不退，你再发汗，或其他治疗，那是错的。不要用其它的药，你得着眼在“为有血也，当下之”。它不用抵当汤而用抵当丸的道理，它这证候呀，不那么急没那么剧烈，这个人也没有如狂也没有发狂，只是热不解而已，所以不要大下。它用抵当丸，这个丸药跟汤药这药物是一样的。份量少，虽然是丸，它也是用煎法。跟汤药是一样的，你们看看后面就知道了。上面那个水蛭、虻虫各三十个，这二十个，用量少了，桃仁稍多二十五个，那二十个，大黄一样。可是每次服的少多了，那个分三次服，这分四次，药量少，次数多。你看看底下这个说明就行了，“右四味，捣分四丸，以水一升，煮一丸”有的注家说什么那是重证，不可余药连渣吃，那是胡说八道。它就是伤寒有热一句话攒在这里，用其他解热药还不行哪，只能够下瘀血。由于病不那么峻烈急迫，所以用丸药，用的量非常的少。所以病有轻有重，用药也有大有小这个量。“卒时，当下血”，卒时就是一周。古人是十二时辰现在是二十四小时，你头天晚上吃，第二天当

下血。如果不下，再吃第二丸。

李冠杰：这个条文是顶格条文。

“小腹满”，《宋本》里边呢是“少腹满”。那么《宋本》呢把这个“不可余药”这四个字放到了那个“宜抵当丸”之前，就是说位置上有点差别。

下边我们解读一下：

“伤寒有热”，在伤寒病的基本特征下，同时又以发热为主要的症状反应。那么正是这儿，我们可以明显感觉出，跟其他的论述发热有不同的地方，这里用了“有热”，通常所用的“发热”，这里边就应该含有什么？应该含有这个患者有某些热象。

“小腹满”，也是要辨证一下是水证，还是血证？那么“应小便不利”，就是说如果是水证的话，他就应该小便不利。“今反利”，这就是一个否定，这这也是一个瘀血证。

那么瘀血证有一个很重要的特征在哪儿？就是“发狂”。这一条里没有“发狂”，这个地方是以“小腹满”为主要的一个症状，但是你也要去辨是水证，还是血证。

旁注“为有血也”，也可以帮助我们理解这个本文的意思。“不可余药”，胡老就作过明确的解释，不可用抵当丸之外的其他的方剂，应该这么理解，而不是喝药的时候什么都不剩，不是那意思。

下面小结：

患伤寒且有热，同时又有小腹满的症状，那么如果是因停饮所致的话，则应该小便不利；今患者反而小便自利，此为瘀血证，应该用下瘀血的方法治疗，此为抵当丸主治之证。

简单地看看那个方子：

这个方子也是四味药组成，跟前边抵当汤药物组成是一样，但是药味之间多少有一点点变化：一个是水蛭减少了十个，虻虫减少了十个，桃仁增加了五个。最大的区别就是把这些药捣碎了，捣碎以后分

成四份，然后用水煎一下服。用一升煎成七合，煎的时间很短，稍微一煎就行了。明显这个药量比那个方剂的药量要小，而且看这个条文论述的症状，也没有那么重，没有“其人如狂”之类的。另外呢，这两个方剂的方证与现代应用，在几乎所有的统计资料上边，都是放在一块儿来论述的，其实都一样。

还有一个小问题，咱们学的这三条瘀血证的条文，都有一个“小腹硬满”之类的症状，都有“小腹满”的问题，而且辨证方法也基本相同。从这儿我们可以看出，在临床当中如果碰到这一类的症状的话，在辨证思路就可以得到很大的一个启发。只要是病人说“我的小肚子胀满，挺难受”，要么你去找血证，要么去找水证，这种可能性就比较大。

大阳病小便利者、以饮水多、必心下悸、小便少者、必苦里急也、（127）

胡希恕：它还承上条那蓄水说的。那小便利者，里头也能停水，“以饮水多，必心下悸”，因为饮水多，胃里停水，胃停水，就心下悸。这在《金匱要略》里有，说病人饮水多，心下有留饮，甚者则悸，危者短气。为什么太阳病第 127 讲……小便少者，如果小便少，那样的膀胱蓄水一定苦里急，这个里急就是少腹里急，就是我们上面讲的少腹满，那么这就是说里有蓄水，有这么两种证候，那么就不是由于饮水多，心下悸，那也是停饮，胃有蓄水，如果膀胱蓄水，一定少腹满而里急，它是这样的。里头停饮，太阳病有影响的，前面讲很多了，那么在辨证上这也是挺重要的，他要是胃蓄水绝对的心下悸，甚至说要短气，这个前面也都有了，那么要是由于小便不利造成下焦蓄水呢，就是膀胱蓄水了，他一定少腹里急，小腹发硬满。

李冠杰：本条文在《康平本》中为降二字格排版条文。

解读一下：

“大阳病、小便利者、以饮水多、必心下悸”，是论述的通常情况下患太阳病后饮水过多而容易出现的一种情况。“大阳病”为阳性表证，并无体液代谢方面的障碍，小便也是正常的。此时如果饮水过多，小便自然就会畅利。但是由于有表证，人体会有一种自下而上的气上冲的趋势，而饮入过多的水后一时难以吸收，在气上冲的作用下就可能发生“心下悸”的症状反应（近似于茯苓甘草汤证的机理）。

“小便少者、必苦里急也”，如果饮水过多，但是小便反而偏少，说明存在体液代谢不良的因素，患者则可能因腹内停饮而出现“里急”感觉。

小结：太阳病，表现为小便畅利的，通常是由于饮水过多，可能出现心下悸的症状。但是如果饮水多反而小便少，则可能出现里急的症状。

辨大阳病 结胸^①

注：《宋本》作“辨太阳病脉证并治下第七”。

问曰、病在结胸^①、有脏结、其状如何、答曰、按之痛、寸脉浮、关脉沉、名曰结胸也、（128）何谓脏结、答曰、如结胸状、饮食如故、时时下利、寸脉浮关脉小细沉紧、名曰脏结、舌上白胎滑者难治、（129）

注：“病在结胸”《宋本》作“病有结胸”。

胡希恕：这是一个以问答的口气来解释这个结胸证，他说，病有结胸，结胸者，实质是结于心下，而上及于胸膛，是这么一个病，什么结啊，水与热结，后头有的。那什么叫做脏结呢，就是脏器本身而有邪结，邪结于脏，就是结于内脏，谓之脏结。他说，病有这么两种，有结胸，有脏结，那是什么样子呢？他说，按则痛，按则痛指的心下，寸脉浮，关脉沉，他主要结在胸膈这个地方，尤其是心下部位，还是胃的部位，他在这块解释了，格阳在上，所以寸脉浮，我们人体大气都来源于胸膺，心肺所主的地方，这个上下的阻隔，所以这个阳气不

得交于下，所以寸脉浮，关以下，所以沉，气不得往下走。我们前面讲的促脉，所以下之后脉浮者，不结胸者，此为郁结也，不是有那么一条么。这个促脉，就是寸脉浮，关以下沉，就是这个脉，这就叫结胸，这种脉加上按之痛，结胸证痛得相当厉害，要是重病不按也痛。

何谓脏结？答曰：如结胸状，饮食如故，时时下利，寸脉浮，关脉小细沉紧，名曰脏结。（沉紧，不是沉结，我说错了。）舌上白胎滑者，难治。这个脏结，跟结胸状差不多，也是拒按，按着也疼，但是它呢，脏结多见阴证，少见阳证，时时下利，这就是阴寒下利，寸脉浮，也是这样子，中有所结嘛，寸脉是浮，而关脉不但沉而且小细紧，小细言极虚，紧者言其寒所以关脉也指胃，就是说也影响到中气的虚衰，所以关脉小细沉紧。中气虚衰而且有寒，那么这个呢，叫做藏结，内脏发生问题了，邪结于藏，在这本书里，这个藏结大家都不能知道，据我的体会，恐怕说的是肝癌这一类的，我们课本后面就有。

舌上白胎滑者，难治。

这种脏结，大概都是有寒有热之象，白胎滑，这个苔啊，舌有苔都是热象，但是滑，它是一个湿，那么，总是多湿多寒，而夹杂着有热，所以是白胎滑。那么这种是藏结也好，结胸也好，都得攻，那么如果有虚，再有寒湿夹杂不能攻呢，所以一定是难治的。

李冠杰：这一条在《康平本》里边是降两字格排版的内容，一般我们常把它说成出自王叔和之手。条文当中“病在结胸”在《宋本》里边是“病有结胸”，应该说《宋本》表达的更准确一些。

下边简单的解读一下这个条文：

这个条文用了问与答的方式进行论述，在《伤寒论》里边这一类题材的条文它有一个规律性，基本都出现在降两字格排版的条文当中，实际上口径是一致的，出自一个作者之手。我们从这儿能够得到什么样的启示呢？《金匱要略》里边很多这样的条文，这些条文不论是理论观点也好，写作风格也好，实际上跟《伤寒论》里边的此类条

文，还有那个降两字格的条文，都是一脉相承的。鉴于此就有咱们的同学建议再把《金匱要略》整理一下，把这一类的条文剔除，我的观点是，我们从古人那里继承这有数的东西，总共包括《金匱要略》也就 800 来条的内容，内容不算多，能够深入的理解，准确的领悟，就是我们现在的当务之急，我们要紧的不是把它精简，而是能够正确的去理解它的精神实质。这个条文有两个重点：一个说的是结胸证，另外一个说的是脏结，还有这两种病的主要特征和区别点。从这个条文来看，结合后边的条文整体来解读，这个条文的作者对结胸证的脉象的论述，应该说是经方理论的一个重要的补充。因为这个结胸证它的病理主要就是水与热结于胸腹，应之于脉它容易表现为寸脉浮、关脉沉这一类的脉象。从大陷胸汤证的临床统计资料来看，这一类的脉象出现的几率也是比较高的。但是值得我们注意的是，并不是所有的结胸病患者都表现为这个脉象，关于这个问题我们在讨论大陷胸汤证的时候我们还会详细的讨论。还有一个问题就是这条论述的另外一个很重要的内容就是“脏结”，关于脏结的论述在整个《伤寒论》里边只有三个条文，而且这三个条文都是降两字格排版的条文内容，除了我们现在学习的这个，还有第 130 条、167 条。我把它简单的读一下：第 130 条——“脏结无阳症、不往来寒热、其人反静，舌上胎滑者、不可攻也”，第 167 条——“病胁下素有痞、连在脐傍、痛引少腹、入阴筋者、此名藏结、死”。从所有的关于脏结的论述的条文来看，脏结应该是一种重病，按胡老的说法有点类似于我们今天说的癌症这一类的病。但是对于这一类的疾病的论述，经方理论当中没有明确的论述，也没有具体的治疗方法，这是一个什么问题呢？实际上经方理论里边就没有这种病，“脏结”的引入，很可能就是这个条文的作者从临床实践当中总结出来的，或者是借鉴其它医书上的对疾病那种划分，从那儿借过来一个，也就是说在别的书上有论的脏结，他可能在临床当中碰到过类似的病，但是他觉得《伤寒论》条文里边

没有，那么把它加上了。真正关于这一类的病，经方的论述跟这个不一样，经方不讲具体的脏腑；《伤寒论》论述的这些病里边，有一些也近似于脏结，但不是这么一种说法而已，实际上大陷胸汤证里边应该也包括了类似的东西。按照这一条的论述，脏结的症状反应，它除了与结胸证较为接近之外，“状如结胸”，它同时存在着“饮食如故、时时下利、寸脉浮关脉小细沉紧”，这是脏结的主要的基本特征，是以结胸为基础的。“饮食如故”，就是说症状不是特别急迫，真正的结胸病，那疼的人顾不上吃饭，比这个急迫的多，但是从这个条文的论述看明显的是不容易治疗的病。

下边作个小结：结胸和脏结这两种疾病分别有如下的症状反应：表现为“按之痛、寸脉浮、关脉沉”的为结胸；主要的症状与结胸证近似，但是同时又表现为“饮食如故、时时下利、寸脉浮关脉小细沉紧”的为脏结；此类疾病如果出现“舌上白苔滑”的，则难以治愈。

脏结无阳证、不往来寒热、其人反静，舌上胎滑者、不可攻也、（130）

胡希恕：这个脏结无阳证，全是阴证，不往来寒热要活看，他在底下还有亦云寒而不热，它不是发热恶寒，但也没有往来寒热，就是只寒而无热的意思，不往来寒热，它是偏于阴证，其人反静，静者为阴，动者为阳，阴证都静，其人反静，舌上胎滑者，不可攻也。他在这解释了，脏结属于实，就是不可攻，胎滑就是多湿之象，就是不可攻。

李冠杰：这条条文在《康平本》里边也是降两字格的条文。

下边我们也简单地解读一下：

刚才学了第 128 条和第 129 条之后，我们有了这么一个印象就是，这这也是一个基本的概念吧：脏结这是一种重症，所以说凡是发生

此类疾病的人体必定是有机能沉衰的这么一种情况，如果机能偏于亢奋一般不会发生这么重的疾病。所以这里说“脏结无阳证”；还有另外一个因素，中医里边脏和腑是明显分开的，一般实心的为脏，空心的为腑。这里的“脏结”就是指的那一类的“脏”，凡是这一类的疾病，比如肝、心或者肾这一类的器官，如果发现有结的这种情况的话，跟消化道里边的有所实物的结实从本质上是不同的，往往都是在阴证的情况下发生的，这是他的论点。

“不往来寒热”，我们在这儿怎么理解它呢？因为脏结多为胸胁部这一类的症状，咱们刚才说了嘛“状如结胸”，都有胸胁部这一类的症状反应，所以这里特别强调他没有少阳病，我们可以这样去理解。

“其人反静”，由于人体机能沉衰，抗病的能力下降，虽然说病重，但是病人反而表现的比较平静，跟阳证正好相反，阳证一些重病有时候表现为“其人如狂”。

“舌上苔滑者”，说明人体不单单是属于阴性证，同时还有停饮这么一种情况，我们现在常常叫“舌上水滑”。其实在经方理论里边早就有明确的论述，对于阴证不可使用下法，阴证无下法，所以这个条文里边也明确地提出了“不可攻也”。

下边做个小结：凡脏结没有阳性证，不往来寒热，其人反静，舌上苔滑的，不可使用攻法治疗。

病发于阳、而反下之、热入因作结胸、病发于阴而反下之、因作痞也、（131）

所以成结胸者、以下之太早故也、（131）

结胸者、项亦强、如柔痉状、下之则和、宜大陷胸丸、

①（131）

注：《宋本》此处有大陷胸丸方及方后注，此从略。

胡希恕：病发于阳，就说的是太阳病，病发于阳，应该汗解，而反下之，这是误治，那么虚其里，热趁虚而入，所以常常造成结胸证。病发于阴，而反下之，阴证没有下，所以病发于阴，阴证大概都用温补的时候多了，没有用下法了，而反下之，因作痞也，这个痞，不是咱们讲心下痞那个痞，他用这几段都论的结胸、脏结，这个痞是痞块儿，就是脏结。

我们后头这个太阴篇就有了，太阴篇，腹满而吐，时腹自痛，前面有，下之是痞下结硬，胸下，心下结硬，有那么一个，所以那个也是一个，这个痞大概就指的这些说的。（273条），太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛。若下之，必胸下结硬。所以阴证不能下，下之伤及脏器要促成硬块，痞块。这个痞，不是心下痞，因为什么呢，没有一个阴证下的而为心下痞的，所以书啊，要前后看，要有依据可以那么解释，那么注解这个地方，这么说的，伤寒，太阳伤寒下之即作痞，这是不对的，有好多伤寒下也成结胸的，有很多中风下之，也有结胸，也有痞，所以，这个不是指的伤寒中风说得，阴证根本没有下法，所以下之而促成，大概这个痞就指脏结。那么这个，本来脏结是不能治，他这个书啊，这一段是以说结胸为主的，所以底下把这个脏结就撇开了，所以成结胸者，以下之太早故也。那么这个病该下应该下，所以成结胸，就是表证未罢，下之太早的缘故。那么至于这个阴证下而为痞，阴证就干脆无下法，不论早晚，不论迟早，那么阴证下之，什么时候也不可下，没有早晚之说。这个阳证在表就下，那是早，已经陷于阳明，陷于里了，那下的就对了，在这解释的是这句话，第一个说治疗的，所以与这一段不是一起的。

他说结胸者，项亦强，如柔痉状，这个柔痉，这个书啊，都是用的这个病字旁和一个至字，应该是这个痉，《玉函经》都是这个痉，就是痉挛的痉，《难经》也是痉，赵开美本，一个至字，有问题这个字，可是大家都管它念痉，那么这个柔痉，这也是柔痉、刚痉，这是

《金匱要略》痉湿喝病那一篇里头的，这个痉，就是肌肉骨骼发痉，甚则背弓反张，就是咱们见的抽，在表证就这么两种，有刚痉，有柔痉，以伤寒没有汗这种证型出现的叫做刚痉，就是用葛根汤治，葛根汤，就是项背强几几，几几的样子，如果项背强达到高度，他就要抽，就要背弓反张了，叫做痉，没有汗的那种痉那就是葛根汤证，用葛根汤主治，要是自汗出的那种痉，叫做柔痉，就是形如桂枝汤了，形如桂枝汤证用桂枝汤加瓜蒌根，桂枝汤本身不能治痉，桂枝汤那个痉，就是组织枯燥，津液丧失多，组织枯燥，肌肉失和，就发痉，那个痉挛很轻，所以身体殊殊然而已，觉得全身发紧，那个不象刚痉。那么这个结胸，这个面扩展的大了，也觉得沿袭到太关上了，这个结胸证呢，主要是水和热，那么也能使这个象柔痉那样身上发强直，他说项背也强，就像柔痉的那种情况，这个，下之则和，宜大陷胸丸。

这个大陷胸汤、大陷胸丸这个药相当的厉害，但是这个丸药还是比较缓滞，他这个只是强而已，但是结胸按着当然也疼，不象陷胸汤那么涌峻，来的暴烈，所以他用丸药不用汤，那么这个药，他是这个，主要用的甘遂，他这个方子大黄、葶苈子、芒硝、杏仁，那么大黄、芒硝都是攻里的，他这个主要还是有热结于里，同时也有水，葶苈子、杏仁都是祛水的，那么另外呢，他用甘遂，甘遂呢，这是个毒药，但祛水的力量相当的有力量，看看底下这个，这个甘遂末是另搁的，又四味，捣筛二味，内杏仁、芒硝，就是大黄、葶苈子这两味捣筛了，然后把杏仁、芒硝搁到里头，合研如脂，杏仁，这个东西和我们讲的桃仁是一样的，它一研如脂，和散，把那两个药面也搁里头，取如弹丸一枚，这个弹丸，就咱们指那个弹弓子那么大，别捣甘遂末一钱匕，白蜜二合，水二升，煮取一升，温顿服之，一宿乃下。他这个药用的很轻，上面那四味只弹丸那么大，那么加上甘遂末也非常地少，一钱匕，这个一钱匕，这是古人的一个，这个匕是一个勺的意思，它是一个，古人舀这个药用的一个器皿，一钱匕，它是指古时候一钱，

一勺则是一钱，古时候一钱合现在很少了，他一两合现在三钱，他一钱合现在三分，量很少很少了，然后加上蜜，那么这个蜜，我们刚才说的是甜的都缓，它也缓疼，也缓药力，煮取一升，把甘遂末和那个丸药搁一起煮，煮一升，温顿服之，一宿乃下。所以这个药用的量轻，你看大黄、芒硝又加上甘遂，但是他用的轻，所以，一宿乃下。如不下，可以更服，取下为效。这个大黄、芒硝这个药啊，只能够攻下、祛热，它配上什么它起什么作用，你象前面那个讲瘀血，它配桃核、水蛭、虻虫、丹皮这类药物，它就下血，它配上黄连、黄芩这类药物，它就下热、解烦，它配上祛水的药就下水，那么这个呢，它既下湿祛热又下水，所以，对这个结胸证，在这个用药就看出来了，它不但有热湿，而且有水，就是水热结合到一起的这么一种病。这在临床上，这个病很少见，但我是确实见到过，这个病凶的很，我们讲这条，大陷胸丸这个证候并不重，底下讲的很多重的，重的不得了，我见过一个病人，但是一定要住在医院，我到医院人就死了，我不必说哪个医院了，他医院给诊断错了，所以结胸证容易死人的，他一看那样子疼啊，从心下到肚脐，脐硬如石，他里头有东西了，这是在解放以前了，解放以前旧社会，小医院，给人家剖腹，一剖完人就撂下了，所以结胸这个病啊，后头有，后头讲大陷胸汤的时候有的是，我再讲两个小段。

李冠杰：第 131 条在《康平本》里它是分成三个小段落，在《宋本》里边给合成一段了，我们这里把它分开来学习。

病发于阳、而反下之、热入因作结胸、病发于阴而反下之、因作痞也、（131）

这条在《康平本》里是降一字格排版的条文，而且这个条文和后边的两小段内容在《宋本》里边是合为同一条。

解读一下：

“病发于阳、而反下之”，这里的“阳” 是指的阳性证当中不

可用下法来治疗的那部分，大家想想，大承气汤算不算阳性证？小承气汤算不算阳性证？肯定是。这个就特指阳性证中不可下的那部分，比如太阳病、少阳病，甚至包括一些阳性的停饮证，这些都是用泻下的方法治疗不太合适的。要如果用泻下的方法治就是误治了，所以说“而反下之”，反下之就不对了。

“热入因作结胸”，这个“结胸”就是说的结胸证了，就是说结胸证可以由阳性证误下发展而来，“热入”确实有外邪内传的意思。人们得了表证以后常常有发热，他认为这就是表热，如果误治了以后那里边就热了，这是表热传进去了，前边说过多少次了，我们今天解读不要这样理解，甚至包括有一些咱们常说的寒饮入里，日久化热之类的，其实都没有道理的。化热也就是说人体在不同的层面上抗御疾病的过程当中，热了就是热了，寒了就是寒了，不是哪到哪，它是疾病的一种发展和变化，没有必要非得说是以前的某某因素发展过来的。特别是像咱们学经方，经方里边好多论的是病因，不是那种病因造成的，有同样的症状反应，用同样的方子来治，所以说病因在这不重要。其实经方是不重病因的，说透了这个道理是一样的，是热入也好，不是热入也好，这都不重要，但是按我们今天对疾病的认识来看，它不是外边的病长驱直入引起里边发病，不是那样的。就是人体抵抗力不断的减弱，在与疾病的抗争过程中人体的抵抗力不断地降低，没有战胜疾病，反而败下阵来了，就会在病理更深的一层的地方发生新的疾病，而不是外边的疾病长驱直入，不是同一种致病因素由外到里一下致病，不是所有的病都由这一个因素造成的。但是这个地方说了一个结胸证形成的原因，就是说阳性证，不可下而用了下法之后，有可能造成结胸证。

“病发于阴而反下之、因作痞也”，无论是何种类型的阴性证，都不可使用下法，一旦误施下法，就可能发生痞。这里的痞应该理解它不是像半夏泻心汤中那种“心下痞硬”那一类的“痞”，而是指的

类似于脏结之类的疾病，但是这里就叫作“痞”。由此可见，前边降两字格的条文的作者把脏结引入进来，这个降一字格条文的作者就不是这么一种定义，他把它叫做痞证，而不是脏结，所以说这儿你要品有这种意味。

做个小结：对于不可下的阳性证，误施以下法，可能造成结胸证；如果对于阴性证误施下法，则可能发生痞证。

接下来第 131 条的第二部分：

所以成结胸者、以下之太早故也、（131）

这条也是降一字格排版的条文，它和上一条和下一条在《宋本》里合并成同一条了。

下边解读一下：

这条论述的是造成结胸证的一个常见的因素——“下的太早”。肯定这不是唯一的因素，中医里有“下不厌迟”的说法，为什么呢？因为所有的下法都属于攻伐的治法，对于人体它都有一定的损耗，如果方剂与症状能恰好相对应，这是为了治愈疾病而必须为之，比如大承气汤证，他里边结的厉害，再不让他吃就不行了；大陷胸汤本身就是一个峻下剂，你再不让他吃，怕攻伐他的正气，人很可能就要不行了。但是要吃了像有一些巴豆剂之类的，让“糜粥自养”这是为什么？就是下过以后人虚了，要有一个恢复的过程，所以说下法对人体都有一定的损耗，只是说方证相应的情况下对人体的损耗要小一些，因为人体本身就有这种偏差，对人体的副作用要小一些。但是“下之过早”的实质是什么？就是结实的程度还不够，换句话说就是方与证还没有达到相应的程度，所以叫“下之过早”，它就容易引起其它类型的疾病，结胸证就是其中的一种。但是要如果全面的看，前边还有其它的论述，还有比如说太阳病误下了以后，反倒太阳病好了，也没有发生别的病，这种情况也有，第 58 条论述的就是这种。像这个我们都得客观的看，这只是可能造成这类疾病的原因之一，它有多大的必然性，

谁都不能给它定一个量，这里边隐藏着好多像生理、医理、病理的一些道理，刚才咱们整个的解读过程就是想说明这么一个事。为什么阳性证下了以后会出现结胸？其中有一个必须得肯定的一个因素，就是绝对不能是可下之证，下了肯定是误治，这是其一；另外还有其它的因素存在，到第 134 条里就看的很明显了，它不是一般的太阳病，太阳病里边有了别的因素存在，才有可能造成这种情况。

做个小结：结胸证常是由下法使用过早而造成的。

第 131 条的第三部分：

结胸者、项亦强、如柔痉状、下之则和、宜大陷胸丸、（131）

这一条里有好多需要我们弄清的问题。首先，在《宋本》里条文的后边有大陷胸丸的方剂及方后注。这条也是降一字格的条文，这三条应该是出自同一个作者之手，但是《宋本》后边有大陷胸丸的方剂和方后注，可是《康平本》没有。这一类的情况，如果是比较版本的话，你会发现多处存在这种情况。《康平本》的一个特点是什么？除了有些方剂没有以外，比如桂枝加桂汤和新加汤，它直接就没有方剂，而且它把这个方剂隐含在方名里边，或者加个简单的说明，其它的地方所有的方剂只出现一次，这就明显的看出《伤寒论》的原貌是一个非常精简的。但是到了《宋本》这个时候这也应该说是一种进步，为了便于阅读使用，在很多重要的条文后边又重复添加了方剂，比如小柴胡汤，有关小柴胡汤的条文有好多，在《康平本》里只在一条后边附有小柴胡汤方剂，到了《宋本》里就在好几个条文后边附有小柴胡汤方剂，这样在学习的过程中，它就会比较省事，使用、查阅起来也比较方便。

但是这个地方却不简单是这个问题，这儿出了什么问题呢？实际上这个地方的方剂是在第 134 条的后边，就是说《康平本》对应的第 134 条大陷胸丸本身是在那个地方的，他把那个地方大陷胸丸给删掉了，删掉了以后移到了这个地方。这一移里边隐藏了很多的问题，这

是我们今天学习的一个重点。它这一改，把整个一个大陷胸丸方剂给糟蹋了，咱们慢慢的一点一点再去理顺。这一改以后，就第 131 条的第三部分这个条文在整个书里成了唯一一个大陷胸丸证的论述了，这影响非常大。实际上这个条文应该说并不复杂，这条实际上是对顶格条文关于结胸证中大陷胸丸证的一个补充，本身这个条文不是正文，或者说本身不是论述大陷胸丸的，它不是原来的专门来论述大陷胸丸证的。原始的条文在第 134 条的后边，这个地方是感觉到那个地方论述的还不够全面，换句话说，这个作者感觉我在临床中还遇到过这样的情况，就做了一个补充，实际上是这么来的一个条文。但是要改成《宋本》以后，就把第 134 条之后那个方剂挪到这个地方来，把那个地方的方剂给删掉了，而且把条文里的方名也给删掉了，这样整个书就成了这一条是论述大陷胸丸证的唯一条文了。真正的原文对大陷胸丸证的论述，也就说最原始的论述反倒是成了没有结胸证的一种黄疸病，等学了第 134 条你会更清楚一些。我们从文字内容上来看，这个条文论述的是大陷胸丸证，而且所列举的这些症状，并不是大陷胸丸证的主症，是补充的，等我们学到第 134 条大家就很清楚了。按说这一类的条文是补充的第 134 条，它应该排在第 134 条之后才合乎逻辑，因为它是对那条的补充嘛。为什么它会排在第 134 条之前呢？大家看一看我们读到这个地方，还有下一条基本上都不是顶格的条文，换句话说要按照皇甫谧的说法：张仲景论广汤液！顶格条文大概就是《汤液经》的内容，这些降一字格和降两字格排版的条文，分别就是张仲景论广和王叔和论广，它本身就是对正文的一个解释性的补充，尤其这个条文是最明显的。但是解释性的为什么要排在正文的前边呢？我们学的是太阳病的第三篇——下篇。我们现在看的书都是纸质的，这个书在汉朝的时候它是写在竹简上的，其实像太阳篇的上篇、中篇和下篇，包括后边这一篇，每一篇形象的说都是单独的一部书，就是单独的连在一起的一捆竹简。假设我们现在拿到一个完整的竹简，你想

往中间加东西的话，竹简和竹简之间都是用绳子连起来的，想往中间加东西你得往竹简的边上写东西，写小字，这叫旁注；但是如果加内容的话，就得把它拆开了，然后再把写了内容的竹简再加进去，这恐怕是一个很麻烦的事。从这个意义上，再回过头来看看《伤寒论》，书里好多条文都是在某一卷、某一篇的头部和尾部，常常都有添加的内容。在头部和尾部添加内容就非常容易了，因为它本身很容易拆。这是我自己在想啊，如果不做这样的解释，你做不出其它的解释来。它为什么不是正文，反倒是解释排在正文之前？这是没有道理的。另外古人它讲究整体阅读，出现这一类颠倒的排版也不算一个什么大的原则问题，所以就出现了这一类的情况。这是我自己的观点，是不是这样子呢？大家如果从史料上找到些依据那就更好了。

我们解读一下：

“结胸者”，指的就是有结胸证的基本特征，才能称之为结胸者，应该后边的条文里对结胸有明确的论述，这个地方就从略了，所以说这个条文重点是补充结胸者还可能出现哪一类的症状。

出现什么症状？“项亦强、如柔痉状”，它就是指在结胸证的基础上如果出现后颈部僵直不适的症状，同时又有近似于“柔痉”的这种表现（“柔痉”在“痉病”里边有专门的论述），就是有汗出的那种痉病。这个地方想说什么呢？就是说如果在结胸证的基础上有这两个症状，也属于大陷胸丸证的症状范畴，所以后边说“下之则和、宜大陷胸丸”。

做个小结：症状似结胸证，同时又有项强并且如柔痉的样子，可以用下法治疗，宜用大陷胸丸。

结胸证、其脉浮大者、不可下、下之则死、（132）结胸证
悉具、烦燥^①者亦死、（133）

注：“烦燥”《宋本》作“烦躁”。

胡希恕：这个结胸病，脉浮，浮者是有外证，表证，有表证，不可下。大者，结未实才大，大者为虚嘛，所以脉浮且大的时候，不可下，下之则死。可见这个结胸证也不能下的太早了。

但是你要给耽误了也死，第二段就是根据这个说的，结胸证悉具者，那是很深入了，就像我说的那种情景，按之如石硬，疼得不得了，那个时候，你还不给陷胸汤，那么待其烦躁，那也非死不可，这个烦躁，光烦不至于，这个躁者，就是乱，所以烦只是热而已，要是烦躁并存，那也必死。咱们今天就讲到这，这个结胸呢，现在我这么说也不容易理解，到后头咱们讲讲才行的。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边，也是降一字格排版的条文。“烦燥”这个“燥”是“火”字旁的，在《宋本》里边它是“足”字旁的“躁”，应该是《宋本》里边这个字更准确一些。

下边我们解读一下：

对这个条文我们需要客观的来看，因为这一类条文的作者对脉比较强调，但要是强调的离开了事物的发展规律的话，咱们也应该予以纠正。就看这一条：“结胸证、其脉浮大者、不可下、下之则死”，这就是一个大问题了，关系到人命的问题，也关系到医疗事故的问题。实际上这一段是这个条文的作者给它总结的大陷胸汤的一个禁忌症之一。但是从临床统计资料来看，并不像他说的这么绝对，——“结胸证、其脉浮大者、不可下”，你要下人会死——“下之则死”嘛，临床统计资料当中确确实实有脉浮大这样的情况，我们怎么理解这个条文呢？这个脉浮大它不是结胸证常见的脉象，在这个地方提出这个问题来就是提示读者：如果认为你面前这个患者是一个结胸证，他要表现为这种脉象的话，你应该仔细地审查他还有没有其它类型的疾

病，如果有的话你一定要小心，不要造成医疗事故。我们对这个事，因为像这一类的经典书，凡是提出一点异议都得有充足的依据。换一个角度：假设说我们有这么一个患者，他表现为确凿的大陷胸汤证，但这个脉是一个浮大脉，这实际上形成了一个什么样的局面呢？就是中医里面常说的‘舍脉从证’的情况：他各种症状都说明了，他就是一个大陷胸汤证，但是就是脉象统一不起来，这个时候该下你也得下，该用大陷胸汤你也得用大陷胸汤。我们再把视野拓宽一点，像这样的问题不仅仅是大陷胸汤证有，跟这个大陷胸汤比较类似的另外一个方剂大承气汤，大承气汤和大陷胸汤常常放在一块儿去鉴别，有时候表现得非常相似：一个是热与水结，一个是热与食结。那么它们都是急危重病，疾病的性质也有比较相同的地方。我们看看大承气汤证临床统计当中表现出来的脉是什么样的，因为它能说明问题啊。大承气汤临床统计资料当中统计到的脉象 28 个：有沉脉、数脉、滑脉、实脉、弦脉、洪脉、大脉、长脉、弱脉、细脉、紧脉、伏脉、缓脉、微脉、厥脉，还有一个浮脉、迟脉、结脉、代脉、涩脉、虚脉，有力的脉、无力的脉，应指似有似无的脉、欲绝的脉、小脉、濡脉、滞脉，二十八种之多。说明什么？这一套资料就支持我们刚才那个观点：如果这个人各种症状都表现为某一个方证，但是他就是脉不是这个方证的脉，应该舍脉从证，对不对？你看大承气汤什么样的脉几乎都可能表现出来，那没关系，他只要是表现为大便不通，这个腹痛，里有结实的这一种拒按，你认准了它是大承气汤你就应该用。如果说我们进一步分析这到底是一个什么性质的问题呢？究其原因这个问题的本质就是人体的不均衡性所致。我们必须得承认，这是事物的本来面目，不能我们一厢情愿的说我这一段时间特别重视脉诊了，然后我就把脉诊强调的比什么都准确，必须客观的去看，实际上这就是人体的不均衡性所致。脉象的实质就是人体患病以后在循环系统的一个反应征象。其实我们摸的是什么呢？是循环系统工作状态的一种，而且现在我

们只是摸桡骨动脉，按我们古代的脉法除了看桡骨动脉还要看其它地方的动脉，那你摸到的还是有区别的；或者说这是循环系统里边反应出来某种病的一个投影，但是由于这个人体它本身就存在着不均衡性，所以有的时候脉象反应的是疾病的实质，有的时候脉象反应的是疾病的一个表象。人体是一个有机的整体，这是我们中医的一个基本的观点，得了病在脉象上它必会有反应，但是它反应的是不是实质？这不一定。我常跟大家打那个比方——“同一棵树上的苹果都不一般大”，为什么呀？就是有的获得的营养多，有的获得的营养少。我们人体也是这样：同样的病常常通过很多方式反应出来，得同样病的两个病人的疾病反应完全一样的多吗？也不多。因为人体有不均衡性。所以无论症状也好，还是脉象也好，甚至包括体质等，很多因素都可以作为我们辨证的依据，但是我们都不能机械的去看，都不能把它绝对化了。一旦有了个绝对化的东西，经方就变得非常简单了。正因为没有，古人总结了这些方法，经历了漫长的时间。所有的人都有这么一种主观愿望：能不能找到一条捷径？能不能找到一种完美的用好这些方子的办法？它没有。怎么办呢？只能是个什么样就记录一个什么样。大家看看经方是不是这样？很多病比如说柴胡证——“但见一证便是”，后边的含义是什么？在不同的人身上它反应会不一样，很少有人四症俱全，但是他都能用这个方子治好。如果按照我们今天去对病的话，那就更麻烦了，像小柴胡汤治那么多的炎症，几乎涉及到各个脏腑，要对着病去治的话，那它就没有稳定性了，几乎无规律可循。但是对证，它有规律，但是这个规律是活的，是一个可塑性很强的，不是稳定的。其实我们学经方的全部过程，就在于把握这种变化的症状反应，把这个把握好了，经方就用的比较自如了。

从另一个角度看，这个条文它必定是这个作者有类似的临床经验，所以说我们还得客观的看。像大陷胸汤，是一个泻下重剂，用的不当就有可能发生很严重的医疗事故，凡是还有其它疾病可能的那种

征象，都要认真的对待，不仅仅是一个脉象的问题，其它的证也应该这么看。只要是还存在着大陷胸汤证以外的其它的证的话，一定要重视起来。

“结胸证悉俱、烦躁者亦死”，这里论述的实际上是大陷胸汤证延误了治疗时机，治迟了。治的早了不行，晚了也不行。迟了以后造成疾病进一步恶化，甚至患者出现了烦躁。这儿的烦躁它是一种重症，是一种躁扰不安的一种急危重症，尽管在很多方证里边都能出现“烦躁”这个症状，但是这个烦躁要比别的地方程度要重得多，而且病情重。“结胸证悉俱”，本身就说明有问题了，就是说所有的结胸证都暴露无疑了。换句话说就是最佳的治疗时机，加上烦躁，就已经错过了，像这个就不太好治了，这恐怕也是临床当中的一个经验。

有一个医案：一个快餐店的老板，前年的夏天，他突然跑到我哪儿，说你赶紧给我看看吧，我肚子疼。他按着胃这个地方，疼，家属跟我说他中午生了一口气，心里不痛快，回家了以后在冰箱里拿出来凉肉，然后又喝白酒，吃完了后时间不长，他就感觉到胃里边疼得厉害。他主诉说得很有形象：他说我感觉我肚子里边的肠子就像肠子破了泡到辣椒水里边那么厉害。他一说这我马上就想到了这个方证，得找依据啊。一按疼，不愿意按，摸摸脉、看他不像痛得多么很重啊？看他叙述得很厉害，但是他人行为什么都很正常。因为他前边一直在吃的柴胡剂，他有多年的胆囊炎，我给了他一剂大柴胡汤。我说你吃下去以后等下午的四点钟，咱俩再见个面，中间差两个多小时。这中间我手头上没有甘遂，我去找甘遂了，找到了以后心里就踏实了。后来四点钟我往他那儿去，他下楼，他说不行，疼得更厉害了，我想应该是了，把甘遂买回来后给他做成散剂，按着原方的比例配好了，一共给了他 20 多克，让他一次把它都用开水泡好频服，一会喝一勺、一会喝一勺，什么时候感觉有要大便的意思了，打住，药就不要服了。到了第二天的上午，我上班以后，他就到我那里去了，人就好好的了，

抱着孩子去了。我说昨天到了什么时候？他说到了晚上的十点多；我说解了几次大便啊？他说没解大便，吐了，他说吐出来了一大盆水。意思是说他没有喝那么多水，但是他吐出来了水很多，就这一次就好了。但过了两个月，又复发了一次，就如法炮制，又给他做了一次，喝了还是吐了，后来好了。后来他自己说他村里的一个人，他的亲戚也是得的这个病，到最后疼的（那时候农村是炕）在炕上打滚，到最后疼死了。这就是属于那种“烦躁”，到那种程度以后就不好治了。再说像这一类的病，一般如果说不用经方的话，基本上早也很难治。

下边做个小结：患结胸证如果表现为脉浮大的，应该细加审查，不可轻易使用本方，以免造成医疗事故；如果结胸证俱全，同时又出现烦躁的，则治愈的可能性很小。

大阳病脉浮而动数（注）浮则为风·数则为热·动则为痛·数则为虚·（经）
头痛发热、微盗汗出，而反恶寒者、表未解也、医反下之、
动数变迟膈内拒痛、胃中空虚客气动膈·短气躁烦、心中懊憹、阳
气内陷、心下因硬、则为结胸、大陷胸汤主之、若不大结胸
①、但头汗出、余处无汗、剂颈而还、小便不利、身必发黄
也②、宜大陷胸丸③、（134）

注：

1. “若不大结胸”《宋本》作“若不结胸”。
2. 《宋本》无“也”字。
3. “宜大陷胸丸”《宋本》作“大陷胸汤”。

大陷胸汤方①

注：《宋本》无此方名。

大黄六两去皮 **芒硝**一升 **甘遂**一钱匕

右三味、以水六升、先煮大黄、取二升、去滓、内芒硝、煮一两沸、内甘遂末、温服一升、得快利止后服、

大陷胸丸方^①

注：《宋本》无此方名。

大黄半斤 葶苈子半斤^①熬 芒硝半斤^② 杏仁半升去皮尖熬黑

注：

1. “葶苈子半斤”《宋本》作“葶苈子半升”。
2. “芒硝半斤”《宋本》作“芒消半升”。

右四味、捣筛二味、内杏仁芒硝、合研如脂、和散、取如弹丸一枚、别捣甘遂末一钱匕、白蜜二合、水二升、煮取一升，温顿服之、一宿乃下、如不下更服、取下为效、禁如药法、

胡希恕：这节啊，就承着前边，病发于阳，而反下之，热入因作结胸。就接着那段陈述其证治，太阳病，脉浮而动数，这是说这个太阳表证的时候，脉浮，病在表，脉浮嘛，动，也是一个脉，动啊，王叔和说它这个关脉如豆遥遥谓之为动，其实这个是有问题的，所谓的这个动，就是脉跳扑摇摆，这就叫做动，也就是滑的厉害，这个脉啊，跳扑摇摆，不论在哪一个部位上，都象在动，不一定得限于关上。数就是快了，底下这几句话就解释这几个脉经常所主的那个病证，浮则为风，脉浮在表，这是风邪的意思，数则为热，脉数就是有热，动则为痛，这个脉要是动，就是摇摆跳扑这种脉都是疼，主痛。数则为虚，数主热，热盛伤及阴液，也主虚，那么这个在肺结核的末期，这个脉都细数无度，那就是数在那时候主虚，所以数脉又主热，又主虚。头痛，发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也。那么病在表者，头痛，发烧，微盗汗出，这个证候和这个脉象正相应。浮则为风，所以这个

病也象外表的证候，头痛，发热。数则为热，这个数也是热，头痛，也就是动则为痛，微盗汗出就是虚了，那么根据这个证候与这个脉是正相应的，大概这几句话，不搁也挺好，就是太阳病，脉浮而动数，头痛，发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也。本来就是这样的，中间搁这么一段，注家有说是王叔和搞的，我认为也是，解释这几句话也没什么大意思，那么也就是说，与这个证候相应，那么什么证候呢，就是太阳病在表，而还未解呢，表还未解，他仍然恶寒嘛，那么太阳病在表未解，依法当汗解，大夫而反下之，动数变迟，下虚其里了，那么虚其胃气，所以这个动数…，正邪纷争，这个拒痛就是正与邪相争而疼痛，在哪呢，在膈内，膈内就指胃，胸膈的膈，就指胃说的，底下就相应解释了，这就由于误下胃中空虚，这个客气就指邪气，趁胃中空虚而动于膈，也就是说这个表邪，热邪乘着下后胃中虚，邪内陷而动膈，这个意思，那么邪到里头了，所以心中懊恼，烦躁的意思，烦躁焦虑，甚至心中懊恼。阳气内陷，心下因硬，这个结胸证只是热它不结胸，同时由于阳气内陷，在表证的时候，阳气是重于表，那么由于吃泻药，这个邪气乘虚内陷，外边的体液、水分，阳气就是水分，就是咱们说的精气了，就是人的体液，我们讲太阳病开始的时候讲了，表证的时候尽量把体液往体表输送，那么由于这个病入里了，体表的津液也往里面撤，所以阳气内陷，那么既有邪热，又有水分，所以心下因硬，就是水与热结，就为结胸。心下里边硬痛，大陷胸汤主之，那么这就属于大陷胸汤证了。

若不结胸，但头汗出，假若虽然热内陷，阳气也内陷，也有不结胸的，如果不结胸的话，但头汗出，这个热是从里面往上攻了，光头汗出，只是头汗出，这个热不得外越，身上没汗，余处无汗，那么从脖子以下全没汗，齐颈而还，如果再小便不利，这个湿热，咱们说阳气内陷，水分也到里头去了，这个湿又不得外泄，那么这个湿与热相郁于里，身上要发黄的，他搁这段干什么呢，就说明这个结胸证也是

水与热的问题，这个发黄，就是黄疸，也是湿与热的问题，如果湿热结于上，结于胸膈，那就结胸，如果湿与热郁于里而不结胸那就要发黄，用的黄疽的说明，是作为一客，借客以明主，用这个说明这个结胸证也是湿热的关系，他不是在这讲黄疸，那么这两个病统统是湿与热、就是水与热，水热相结，结于胸叫结胸，湿与热相郁于里而不结胸者那就要发黄，结胸的时候要用大陷胸汤，发黄，这个里面没讲发黄的治疗，后头有的，这个大陷胸汤这个药啊，就是一个猛峻的药，比大承气汤还凶，大黄、芒硝用的量都特别重，大黄是六两，这个去皮有的书上没有，芒硝一升，一升就是一茶杯，甘遂一钱匕，甘遂这个药不能多用，这是个毒药，这三味药，以水六升，先煮大黄，取二升，去滓，内芒硝，煮一两沸，这个芒硝不要多煮，内甘遂末，然后把这个一钱匕甘遂末搁到这个药里头，温服一升，得快利，止后服。那么这个药大概吃都是得快利，他就泻下相当的厉害，不要让人连着吃，这个结胸这个病是个大病，这个病是重病，这个大陷胸汤也是个峻药，所以前面有那么两段，由于这个病是个重病，治疗得抓紧得及时，可是药太猛峻，用之不当能造成这个祸害，所以 132、133 这两条，结胸证，其脉浮大者，不可下，下之则死。就是说用这个大陷胸汤，那如果结的不到那个程度，而脉还浮大或浮滑，那都不能用这个大陷胸汤，可是结实之后，人体又发生烦躁不宁，那再吃这个药也不行了，晚了，所以也死，虽下之，也死，所以这个，这种病是少见的，但是我们要是遇到这种病的话，机遇要掌握好的。（这个西医的肝硬变见到，这哪是肝硬变，不是，肝癌啊，恩，肝癌，肝癌哪是肝硬变？不是，我说肝癌见到这种症状，奥，相当于这种症状？奥。）底下还有相应的解释。

李冠杰：这一条是我们今天学习的一个重点，因为一是条文篇幅比较大；再一个《康平本》和《宋本》对大陷胸丸证出现了一个比较严重的问题。我们通过对这条的学习，把它彻底搞清，恢复原来的面

貌。

条文是这样的：“太阳病脉浮而动数”；下边是嵌注内容——“浮则为风•数则为热•动则为痛•数则为虚”；下边是正文——“头痛发热、微盗汗出，而反恶寒者、表未解也、医反下之、动数变迟膈内拒痛”；下边是旁注——“胃中空虚客气动膈”；“短气躁烦、心中懊憹、阳气内陷、心下因硬、则为结胸、大陷胸汤主之、若不大结胸、但头汗出、余处无汗、剂颈而还、小便不利、身必发黄也、宜大陷胸丸”。

这个条文在《康平本》里是一个顶格排版的条文，条文中“若不大结胸”在《宋本》改成了“若不结胸”，去了一个“大”字，变化很大，咱们后边详细讨论；另外“身必发黄也”，在《宋本》里没有这个“也”字，这个倒是没有太大的问题；更大的问题是《康平本》里的“宜大陷胸丸”，在《宋本》里成了“大陷胸汤”，而且没有“宜”字，我们在学习过程中一点一点的把它理顺了。

下边先逐字逐句地解读，条文比较长，我们可以分成三个部分来解读：

第一部分就是误下之前的一种情况，也可以把它看作病因了。误下之前是从“太阳病脉浮而动数”，一直到“表未解也”这一段。

“太阳病脉浮而动数”，浮脉是太阳病的常见脉象，我们都知道的，但是这个“动数”的脉说明太阳病之外，又有了其它的情况了。这段条文论述的是太阳病误下之后出现结胸证的一种情况，这一类的情况“太阳病误下”，咱们前边两篇里论述的就已经很多了，但是同样是太阳病误下，为什么这儿会出现结胸证呢？它肯定应该有特殊的原因存在，“脉浮而动数”这种脉象就是其中的一个，它就想通过这种现象告诉我们这是太阳表证里比较特殊的一种，换句话说，它已经不是一个单纯的太阳病了。咱们再看看这个“浮而动数”的“动脉”，王叔和在《脉经》里是这么解释的：“脉来滑数有力、应指跳突如豆、

搏动部位狭小、脉律均匀的脉象”，是这么一种脉象。但是胡希恕先生的解释是“滑脉之甚”，也就是说滑的比较重的一种脉象，他有的原话是这么解释的：“‘动’，也是一个脉。‘动’啊，王叔和说它这个脉‘如豆摇摇、谓之为动’，其实这个是有问题的，所谓的这个‘动’就是脉跳扑摇动、摇摆，这就叫作‘动’，就是滑得厉害（这不滑之甚嘛），这个脉跳扑摇摆，不论在哪一个部位上都像在动，不一定限于关上”。王叔和对这个脉的解释，胡老显然是非常的熟悉，对这种古人已经有明文解释的脉象，胡老反而又另做理解，它反映出胡老在治学态度上实事求是的这种精神。咱就拿这个脉象来看，如果按照王叔和的定义，这个脉就成了一个非常罕见的脉，就算是在座行医时间比较长的人，这个脉象碰到的机会也非常少，就说跟那个跳动的豆子一样的脉。更为严重的问题是什么呢？这个脉象出在太阳病还没有“下”的情况下，不是一个特殊的病，并不是很特殊，只是在太阳病的基础上，又见了有一点热象，有一点虚象，就是这么一种病。它会不会是那一种脉象？关键是这个问题。所以，胡老在这个地方另起炉灶，另对这种脉象解释，这是一种很实事求是的态度。如果这里解释的脉象几乎所有人都碰不到的话，这种解释就没有意义了。下边“数”，在这个地方出现“数脉”，一是有热的征象；另外如果结合后边误治以后发生的结果，这个“数脉”其中也有虚象的成分，人已经有虚的这种倾向了。这样，“浮而动数”的这个脉象，实际上他就想单从这个脉上看，来说这个人是这样一种状态：在表证的同时又有了里热，而且又有虚证；也就是说既有表证，又有里虚热证的这么一种状态。大家想想，同样是太阳病，为什么在别的地方下了以后出现不了结胸证？为什么偏偏这儿出现结胸证呢？因为这个人有一点特殊的情况，他本身不仅仅是太阳病，已经有热了，而且人又虚，你再下，就有可能造成重症。

嵌注的文字——“浮则为风、数则为热、动则为痛、数则为虚”，

它是对“浮而动数”的脉作了一个进一步的解释，我们上边分析的基本上就跟它相吻合的，也不外乎这些内容。

“头痛发热”，本来应该是视为太阳病的本证，放到这个地方我们应该想象到另一个方面，那就是说阳明病有时也会出现类似的症状反应。因为从脉象里看已经有热了，也不一定没有里热的因素造成的“头痛发热”。

“微盗汗出”，就是有轻微的盗汗。真正的阳明里热它会出汗出比较凶，这个地方也出汗，但是量不大，“微盗汗出”嘛！盗汗就是睡觉以后才出汗的，这是两个因素造成的：一个是里边确实有热；另一个就是有虚的因素存在。后边条文里有“而反恶寒者”，这个“反”字它就特有所指，什么情况才“反”呢？如果存在里热，本来不应该恶寒，但是这儿病人又有恶寒的现象，这个“恶寒”既含着有表证未解的意思，又含着人虚的意思。所以从总体上看，这还是一个表证，以表证为主要矛盾，同时又有里热和里虚这么一种倾向的状态。所以它最后的结论是“表未解也”，就说还是处在表证阶段。

条文的第二部分是误下以后所出现的第一种情况，论述了误下了以后发生了“大陷胸汤证”这种情况。条文是从“医反下之”一直到“大陷胸汤主之”。

“医反下之”容易明白，太阳表证不可下，从上边条文论述的症状看，虽然有里热，但是并没有里实的症状反应，所以用“下法”就是误治，这说的也很明白，“医反下之”嘛。

“动数变迟”是指的脉，误下了以后，原来滑数的很厉害的这种脉象发生了变化，比下之前搏动的次数明显降低。大陷胸汤证未必一定会表现为迟脉，也不一定啊。按照它论述的情况，因为他里边有所结嘛，脉动的次数比以前明显的少了，不那么数了。

“膈内拒痛”，这个“膈内”我们就把它理解成胃及其以上的胸膈部这个部位。“拒痛”这个症状，从“大陷胸汤证”临床表现来看，

这儿应该是说：一方面患者感觉疼痛非常重、剧烈；另一方面它也有“拒按”的意思在里边，所以说“膈内拒痛”。

旁注“胃中空虚、客气动膈”，它意思呢就是说“膈内拒痛”这类症状，是因为误下以后造成虚证，影响人体的胸膈部所发生的，做了这么一个解释。

“短气躁烦”实际上是两个症状。“短气”的病理就是由于热和水结于胸胁，加上胸膈部疼痛影响正常的呼吸，就会有“短气”的感觉；“躁烦”同样还是上边的原因，因为热证影响了人体的精神方面所产生的一种症状。

“阳气内陷，心下因硬”。经方里的“阳气”常常用来代表体液，“阳气内陷”就是指的“水结于里”的一种病理解释。“心下因硬”是因为“阳气内陷”，也就是水结于里之后形成的症状反应。

上边论述的，就是“大陷胸汤证”形成的一种常见病因和典型症状反应，条文最后总结了“则为结胸”，这就成了“结胸证”了，治疗就应该用“大陷胸汤主之”。

整个条文的第三部分，论述的是误下以后的第二种情况，实际上论述的是“大陷胸丸证”。如果只看《康平本》，或者如果没有《宋本》，只有《康平本》的话，对于“大陷胸丸”方剂的理解，绝对不是我们今天的样子。《宋本》对它影响到什么程度呢？我们现在在临床统计资料里，专业书籍的专业班子统计的资料就没有统计到“大陷胸丸”的临床应用，没找到它的数据。为什么会这样？下边咱们慢慢学学，大家就知道了。

这段条文就是从“若不大结胸”一直到最后的“宜大陷胸丸”，《宋本》里没有“宜大陷胸丸”，这个地方是“大陷胸汤”。“若不大结胸”在《宋本》里给改成了“若不结胸”，虽然就去掉了一个“大”字，但是改动了以后，这一句话之后的条文基础都给掀翻了，给从根本上改变了。本来这段条文的意思是：虽然有“结胸证”，但是程度

不像“大陷胸汤证”那么严重，同时又存在着下边所列举的这些症状的话，这就是“大陷胸丸证”，本身条文就是这么个意思，最后用“宜大陷胸丸”嘛！

但是当《宋本》把“大”字去掉了以后，又把条文最后的“宜大陷胸丸”五个字给删掉了，接下来就是“大陷胸汤”的方剂。这样一改，条文的内容由本来的“大陷胸丸证”一下变成了“黄疸病”了。这个条文成了“若不结胸、头汗出、余处无汗、剂颈而还、小便不利、身必发黄”，“身必发黄”后边是大陷胸汤方剂。这个“大陷胸汤”实际上指的是下边那个“大陷胸汤”的方子，它没法跟下边这个“大陷胸汤”去衔接，衔接不起来了。因为这儿是一个“若不结胸”，不结胸只是有这些症状，另外“身发黄”能用“大陷胸汤”吗？不可能用的。所以说这个地方它不能那么去衔接，但是要把“大陷胸汤”跟下边那个“大陷胸汤”方子结合起来呢，那个“大陷胸汤”又缺了一个“方”字，这个地方弄得就很乱。怎么形成的这么一个状态？我们现在没法考证了。

下边“但头汗出、余处无汗、剂颈而还”，这是由于热与水结于里，同时又以停饮为主要矛盾，因为它后边有“小便不利”，而影响到人体正常的排汗功能，所出现的这么一种只是头部有点汗出，身上一点汗没有的一种症状。

下边“小便不利，身必发黄也”，这里的发黄就是指的“黄疸病”，“小便不利”和前边论述的“但头汗出、余处无汗”串起来理解，实际上这就是形成“黄疸病”的病理条件：一方面里有热，有热的机理本身就是人体的机能偏于亢奋，结果就会带来人体内部代谢物质的增多，也就是废物产生的多，这就像我们的汽车一样，当你加油门的时候，后边排气管子排的废气就多的道理是一样的；另一方面，里有停饮，小便不利，同时又因为停饮，导致身上的汗也不怎么出，需要通过体液排出到体外的代谢物，比正常情况下产生的就多，但是出路又

没有，既不能通过出汗的方式排出体外，又不能通过小便的方式排出体外。严重的时候，人体就会发黄，就形成了黄疸病。这一点在《金匱要略》里说得很清楚，在一个方后注里说“黄随小便去”，说得很有道理。往往人有里热的时候，小便会发黄，就是因为人体内部代谢加快以后产生的废物多了。正常情况下小便是微黄，“黄赤”就是黄得很厉害，甚至严重的时候就跟稀释一点的酱油一样，像这个样子的小便，它把人体内部产生的废物都排出去了。但是如果小便不利，这些东西就会停滞在人体内，随着血液循环到体表的时候，人的体表就会发黄，而且一些器官、浅在的血管就会呈现出黄色，像眼球什么的就会发黄。

《康平本》最后是“宜大陷胸丸”，《宋本》把这五个字给删掉了，为什么删掉？我不好做一个合理的解释。如果当时做这种更改的时候，作者感觉到前边有一条是专门论述大陷胸丸的（就是咱们刚才学过的第131条的第三部分），但是这个地方也出现了大陷胸丸证的条文，可是这儿明显的最后出现了黄疸，大概他怀疑这个大陷胸丸是不是能治黄疸呢？会不会是出于这方面的考虑，把它作了更改，现在是不好说了。但是通过我们上边分析，这应该是一个大陷胸丸证。怎么来的，我们还可以再进一步地分析一下。虽然说这里用的“宜大陷胸丸”，没有用“主之”，但是我们从条文里论述的这些症状分析，大陷胸丸它是既可清热，又可除湿，而且它祛水的力量大于大陷胸汤，与这个条文里所列举的症状正好相适应的。大家看看条文里，小便不利，汗又不出，然后还发黄，发黄这也是有热，而且他有结胸证，只是不大结胸而已，没说不结胸，他有结胸证，只是没有大陷胸汤那么严重，在这个基础上又出现了停饮严重，小便不利嘛！也可能会出现身发黄这种情况。

大家看看大陷胸丸的药物组成就能看出来，它跟大陷胸汤非常相似，就是祛水的能力比大陷胸汤要重一些，方与证恰好适应，可就是

不知道为什么给改成这样，后人在遇到这类情况的时候，想不到，或是不知道大陷胸丸可以治这类的病，比如有结胸证的黄疸，或者里有停饮非常重，又有热的这种情况。为了能让大家对这个条文正确理解，我们现在把它恢复过来了，为了能够加深理解，后边我给大家找到了一个医案，最后跟大家说一下。

做个小结：“太阳病脉浮而动数”，说明在表证的同时，又发生了虚热证。其症状表现为“头痛发热、微盗汗出、而反恶寒的”，为表证还没有解除；但是医者反而用泻下的方法予以治疗，结果“脉象由动数变迟、膈内拒痛、短气躁烦、心中懊憹”，津液停滞体内，因而出现心下硬，并发展为结胸证，此为大陷胸汤主治之证。如果结胸证不十分严重，但是却表现为“但头汗出、余处无汗、剂颈而还、小便不利”，甚至可能“身发黄”的，宜用大陷胸丸治疗。

这样我们就把《宋本》改的条文，又和《康平本》的条文重新的理顺了一下。这里边谁有道理、谁没道理，我们都说得很清楚了。

看看这两个方剂。大陷胸汤是由三味药物组成的：大黄六两、芒硝一升、甘遂一钱匕。甘遂是一味寒性的药物，有毒，它的功能是破积逐水，有很强的祛水能力，可通二便，在大陷胸汤中的作用主要就是起祛水的作用。虽然从用药上看它是粉剂，但是它用量只有一钱匕，现在关于这个剂量单位弄得很乱，一钱匕有的地方解释跟一方寸匕是一般大，一般的草木类的药粉大概是 1g 到 1.5g 左右的样子。古代有一种钱，形状就跟一个砍刀差不多，大概是用那个东西去量药，跟一方寸匕衡量药的方法应该是一样的。只是这个剂量的方式不同，估计也应该不会有太大的出入，大概也就是 1g 到 1.5g，或是一般不超过 2g 的意思。相对于其它的药物来说，它这个药量就比较少了，但是从这个方剂的祛水和泻下的功能来看，可以看出甘遂这个药既有毒，而且药性也非常强烈。这个方剂另外还大量地使用了大黄和芒硝，所以说这个方剂祛热和祛水的能力都很强，就形成了一个泻下的峻

剂。由这个方剂也能看出这个疾病的急迫程度，芒硝和大黄的量都非常大，大黄用到六两，可能这是经方里用大黄量最多的一个方剂。

大陷胸丸这个方剂是由六味药物组成的：大黄是半斤、葶苈子是半斤、芒硝半斤、杏仁半升，另外在方后注里边还有甘遂末一钱匕、白蜜二合。我们首先看这个剂量单位有一点小问题：葶苈子在《宋本》里是“半升”，芒硝在《宋本》里也是“半升”，但是这个地方葶苈子和芒硝全是“半斤”。我们必须得判断一下到底哪一个是正确的，我们也做了一个简单的分析，看看能不能把这个事弄清了，如果参照大陷胸汤方中芒硝的剂量单位，那么这儿的芒硝剂量，《宋本》中的“升”应该是正确的。因为大陷胸汤和大陷胸丸，如果一个是用“升”，一个是用“斤”，就有点儿不太合乎逻辑，所以说这个地方《宋本》当中的“升”应该是正确的。葶苈子在所有的经方当中，有这味药的方剂一共有六个，这个大陷胸丸是其中一个，这个方剂先把它放在一边，其它的五个里边：一个方用的是“两”；另外一个方用的是“分”，这个“分”就是“四分等于一两”的那个“分”；另一个方，鳖甲煎丸，它是一个丸剂，我们也可以把它理解成“份”，所以这一个好像又有点含糊了，但是其中有一个是用“两”的，这个是比较准确的；还有一个方剂是与其它的药物是等份，这个也没有份量，等于说没有剂量单位；另外有一个是葶苈子取“弹丸大”，就是把它捣碎了以后取“弹丸大”那么一块儿，这个剂量单位对我们比较也起不到什么作用；还有一个方剂根本就没有量，那就是小儿疳虫蚀齿方。从这些方剂的剂量看，这个地方如果是“半斤”的话，可能倒比较合适，因为有一个方剂中很准确是用“两”了。我做了一下测试，葶苈子如果是“半升”的话，它的重量应该是在 72g 左右，合汉代是 4.8 两，如果把它视为“半斤”的话，就是 8 两了，这个 8 两和这个 4.8 两之间差了 3.2 两，基本上是 50g 的样子，这个差距还是不小的。咱们这个地方就是建议：我觉得应该用“半斤”比较靠谱。

还有一个问题顺便跟大家说一下，经方的药物、方剂这么好，如果因为剂量问题弄不清，在应用当中影响到应用，那就有点太没道理了，所以我对这个剂量有一段时间相当地关注。我有一次在网上找到了一个较全的表格，就是专门为经方这些药物使用列出来的，汉代的什么东西“一升”等于多少，什么东西多少“合”等于今天的多少克，它有一个折算的关系。但是里边好多地方，我们知道的，它基本上还比较准确；我们不知道的，整理这些数据的人也不知道。它不仅仅是这一个，我核对了一下它好几个地方都是不对的，包括石膏。对葶苈子，它说“一升”葶苈子等于 60 克，我实测一升就是 200ml 的量。葶苈子这个东西特别细小，就算是鲜的和干的出入大不了，其实也很难找到鲜的，因为它那么小，如果不把水分晒干，恐怕没法把它打出来，所以说一般都是干的。我实测一升是 145 克左右，刚才我说“半升”是 72 克，我把 0.5 给舍了好计算，145 克左右跟 60 克，那个表格上说葶苈子“一升”等于 60 克，差一倍还多，太不严肃了。你要想给大家提供一个这一类依据的话，葶苈子又不是一种难买的药，就不能自己试一试吗？一个 200ml 的量杯五、六块钱，买上一公斤的葶苈子才花多少钱呢？你就不能把它倒到里边去称一称啊？我对这些所谓的学者们有时候真是不敢恭维。

这个葶苈子是一味寒性的下水药，从经方方剂的应用看，它对肺部、胸部一些热性的、实热性的停饮有比较好的治疗作用。杏仁在这个方剂中其实也是祛胸水的功能，另外它还有宣肺平喘、镇咳祛痰这种作用。这个大陷胸丸从药物组成上看，就是在大陷胸汤的基础上，加上葶苈子、杏仁和白蜜，但是由于它这个剂型很特殊，药物之间的比例变化非常大，其中大黄、葶苈子、芒硝和杏仁要求做成粉，但是一次的服用量只有“弹丸大”这么一点，也就是 1 克。“弹丸大”就是打弹弓用的那个子弹，非常小了，大概像食指的前端指头肚那么大一点，所以说重量非常少。它甘遂的用量和大陷胸汤用法和用量都

是一样的，都是用的甘遂末，而且用的都是一钱匕，相对的甘遂用量就非常大了。所以我们说这个方剂是一个以“下水”为主要目的的方剂，方剂里的蜜是用来缓解甘遂的毒性，也能缓解整个方剂的剧烈程度。

下边是这个方剂的方证和现代应用。

大陷胸汤方证（共 28 例）。

症状：心下至少腹硬满而痛不可近 19，便秘 18，烦躁 13，发热 11，口渴 8，呕吐 8，腹胀 5，不欲食 4，小便黄赤 3，不能平卧 3，吐涎沫 3，短气 2，但头微汗出 2，胸膈痞满 2，头痛项强 2，头晕恶心 2，多痰 2，心中懊恼 1。

舌质（10）：舌红赤 5，舌燥 3，舌干 2。

舌苔：黄燥 5，黄腻 4，苔黄 3，灰黄 2，白厚腻 1，薄 1，腻 1。

脉象（12）：寸脉浮关脉沉 3，沉紧 2，沉弦 2，沉实 1，沉滑 1，洪大 1，洪数 1，脉形似和 1。

现代应用：急性阑尾炎、肠梗阻、粘连性肠梗阻、蛔虫性肠梗阻、轻度肠扭转、机械性肠梗阻、完全性肠梗阻、单纯性肠梗阻、麻痹性肠梗阻（即绞窄性肠梗阻）、胆囊炎、胆石症、胆管炎、肝脓肿、肝硬化腹水、肝硬化之胸水、胃溃疡并发胃穿孔、胃痛、急性胃炎、胃石症、绞窄性膈疝、急性胰腺炎、急性水肿性胰腺炎、胸膜炎、渗出性胸膜炎、结核性胸膜炎、脉膜疾病之胸腔积液、腹膜炎、渗出性腹膜炎、结核性腹膜炎、流行性出血热、脑血管意外、流行性出血热并发肾功能衰竭、肾炎水肿、肾炎之胸水。

大陷胸丸证方证：

因为《宋本》对本方证的改动，对本方的应用产生了很大影响，临床统计资料竟无本方剂的数据。有的书中仅以一句“参照大陷胸汤条”了事。

症状：胸膈疼痛、短气、烦躁、心中懊恼、汗出、项强不适

舌质：红

舌苔：黄腻

脉象：滑、数、紧（沉紧或沉迟有力）

现代应用：常用于膈间留饮；感冒之后，饮食过量，胸脘结痛；癫狂等。

下边是病理：这两个方证的病理都是停饮证，即是水实证，合并里实热证。其中大陷胸丸的水证大于热证，这是一个很明显的。

最后有一个就是关于大陷胸丸的一个应用。大陷胸丸因为《宋本》做了那样的改动之后，临床当中应用的非常少。它改了以后，大陷胸丸成了一个“如柔痉状、项亦强”，然后它有结胸证，前边有那么几个字，常常很多人就理解得不是很好，像“小便不利、无汗身黄”，这个全都给弄到大陷胸丸之外了，形成了一种很严重的误导，造成了这个方剂在临床当中用的非常少。

但是我找到了一个医案，还特别的好，跟大家说一下：这是天津的一个医案，一个男性病人素有“茶癖”（就是他喜欢喝茶水，整天拿着茶壶常饮，手不离茶壶这么一种习惯），身体还比较胖，面目光亮，也就是说身体素质还可以吧，他经常以身体比较健康炫耀。有一次冬季感受了风寒之后，他自行服清宁丸与救苦丹，但是病并没有好，而且发生了胸中动痛、呼吸也不利、项背拘急、俯仰为难（趴着、躺着都不行）。那么经人介绍找到了这个医案的医者，当时诊断的结果是脉弦而有力，舌苔白厚而腻，他辨为伏饮居于胸膈，热与水结于上，为大陷胸丸证，方剂开的是：大黄 6g、葶苈子 6g、芒硝 9g、杏仁 9g、水 2 碗、蜜半碗，最后煎成半碗，再下甘遂末 1 克。结果服了一剂大便泻下了两次，病人胸中顿时感觉非常清爽，又服了一剂泻下了四次，从此这个病就痊愈了，而且他以前喝茶的嗜好也变得淡了。这个很值得我们品味，这个医案非常好！

伤寒六七日、结胸热实、脉沉而紧、心下痛、按之石硬者、大陷胸汤主之、（135）

胡希恕：那么这个结胸证不仅是下多少的关系，也有自发的，底下这两段全是，这个伤寒六七日的时候，就是由表传半表半里传里的这么一个时间，那么人体内根本就有水气，同时邪热内传的时候，也容易发生结胸证，这段就说明这个，结胸热实，既结胸有热实于里，脉沉而紧，沉，病在里就脉沉，沉以候里嘛，紧者，实，这个紧脉这都是有郁的脉了，所以病实脉也紧，你看表证，这个表虚证就是桂枝汤证，脉浮缓、脉浮弱，这个麻黄汤证就是表实，脉浮紧，那么内实这个脉也紧，但是限制于沉不限制于浮，心下痛，心下就是胃的部位，痛，这个痛是自觉症状的痛，按更不行了，也就是说又硬满也疼，按之石硬者，你按就像石头似的那么硬，大陷胸汤主之。那么这个就是说结胸，外边水与热结，里头还是真正的实，他这个前后两段是相互反映的，这段所说的热实，底下这段就不是了。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边是顶格的条文。

下边解读一下：

“伤寒六七日”，咱们已经学了很多这一类的条文，用这些不同的日期来暗示我们一些其他的情况。“伤寒二三日、四五日、五六日”，甚至于到“十日以上”，这种论述都有。他想说明的是不同的日期背后，隐含着一个疾病的程度和人体的体质的不同。这个“伤寒六七日”我们可以把它简单的理解成患表实证已经有好多天了，暗示疾病有进一步发展为其它疾病的可能，从这里给我们提供了一个辨证的条件，它有由表证转为其它类型疾病的可能。

“结胸热实”，这四个字是两个不同性质的概念，“结胸”指的是结胸证，因为前边对结胸证已经有了论述，我们今天学习古人的条文就应该有这样的概念，这里边就涵盖了结胸证的一系列的症状；“热

实”它是一个病理的概念，既有热，又有实，这是经方的病理辨证的两大方面的因素：寒热一方面、虚实一方面。这儿等于跟我们说他的表证得了六七天以后，又出现其它类型的疾病了。具体是什么样的疾病呢？因为热实证是在病理上属于热，属于实，但是具体的方证上，很多方证都有可能是在这种病理上发生的，像三个承气汤证的病理都有“热实”的因素存在。这儿的热指的是里热，实指的是停饮。

怎么知道它是指的停饮呢？后边有“脉沉而紧”，“脉沉而紧”是大陷胸汤证一个常见的脉象。沉为病在里，这个大家都知道；那么紧呢，在这个方证里边它是候里有停饮的，它同时也是疼痛的一个证候。大陷胸汤证一般都伴有剧烈的疼痛，所以说应之于脉也会出现紧脉。

具体的症状：“心下痛、按之石硬”，心下就是指胃的部位，不单单疼痛，而且按之很硬，病人觉得非常的痛，这是典型的一个症状反应，这是胃部的一些比较严重的病变，所以他用石硬来形容他内结的程度，非常严重！

这个条文看起来非常的简，症状也不复杂，但是咱们今天学习古人的条文，我觉得这个条文应该注重这三个小的方面：

一个是结胸证不一定是太阳病误治后发展而来的。因为前边有太阳病误治以后而来，后边也有，这里又特别的列举了这么一条，这个不是经过误治而来的，而且就是太阳病得的天数多了以后，疾病进一步的发展为结胸证的情况。如果根据这个思路我们举一反三的话，不经过太阳病的阶段，也完全有可能发生结胸证，关键是你有没有结胸证的症状。这样我们就理解到了经方的真正的内涵：好多它的病因实际上并不是说这个病一定要以那种方式发生，而是病因里边有另外跟我们需要说明的道理隐藏在里边。这个咱们前面说过多少次了，这是第一点。

第二点这个条文所论述的结胸证，它这儿有结胸这两个字，就说

明他完全有可能像 134 条论述的那种结胸证的症状反应，那种反应都完全有可能存在，但是这一条论述的却是以“胃部疼痛，按之石硬”为典型症状反应的。其它的结胸证的症状可能会有，也可能不全，但是表现最为突出的是：“胃部疼痛”、而且“按之石硬”，这是典型的症状反应。

这里论述的是：在大陷胸汤证的这种病理状态下，而发生的胃部疾患，以胃部得了某些疾病为重点的这一类的症状反应。在临床统计资料当中，就有如急性胃炎、胃石症等等的这一类的疾病，恐怕就是这种反应比较明显一些。大陷胸汤证的这些胃部疾患，按现代医学的疾病分类，比如理中汤也有可能会有胃炎，半夏泻心汤也可能会有胃炎，同样是胃炎，但是大陷胸汤证的胃炎表现的就非常得严重，不单单疼，而且拿手去按一按，“石硬”，它也不是像半夏泻心汤那种心下痞，那个心下痞主要还是主观的感觉，也不同于人参证的心下痞硬，那个硬度绝对没有这么大。这儿尺度说得很到位，就是“石硬”，跟石头一样那么硬。

第三点，结胸证虽然在病理上是由于热与水结，但是其表现形式是多种多样的。从这个条文往后，第 134 条往后一直到第 138 条，都是论述的大陷胸汤证，但是具体的症状反应却各有侧重，不尽相同。

这儿我们去体悟经方论述的一个特点，它像什么呀？我们再回头想一想小柴胡汤证里四大主证里边就有一个说法，叫“但见一证便是”。尽管那是降一字格的条文，但是说的非常的到位，为什么说但见一证便是啊？这个四大主证里头，真正得小柴胡汤证的，四证俱全的不是很多，它往往会侧重于某一个（证）。比如有的人“往来寒热”明显，有的人口苦明显，口苦不算四大主证，其实也是一个主证。有的人就“默默不欲饮食”明显，都有侧重。实际上这些侧重的背后是什么？这些侧重的背后，实际是不同的，按现代医学分类这是不同的疾病。这里边隐藏着很深的道理，如果把这个事揣摩透了，你对现代

医学对疾病的分类，会有一个全新的看法。而且你对古人，特别是经方理论对疾病的划分，你也会有一个全新的看法。

比如小柴胡汤证里边有一个“或咳”，“或咳”指的是什么？“或”是个或然证，有时候小柴胡汤证里边有它，有时候可能没有。有它，小柴胡汤也能治。“咳”指在小柴胡汤证的病理状态下，发生了肺部或者上呼吸道感染之类的疾病。

还有“或小便不利”，这也是个或然证，小柴胡汤临床医案统计里边就有肾炎。实际上这就是在小柴胡汤证的病理状态下，病人发生了肾炎这类的疾病，他才会出现小便不利的。为什么把它放到或然证里边，甚至包括主证也会“但见一证便是”，这是问题的关键。就是说他病理状态是一样的，但是具体的反应症状有时会有很大差异。你再从这里往深一方面考虑的话，你就能领会到我常说的：经方里边方证都是动态的，你要从中去感悟他的规律所在。

另外现代医学对这些疾病的划分，你也会感觉大有值得研究的地方。小柴胡汤证是最明显的，其实大陷胸汤证也非常明显。咱们上次把大陷胸汤所对应的现代疾病给大家列了一下，大家可能从中也能感觉出来，它也涉及到好多脏器。在不同的人身上，同一个病理状态，就有可能造成完全不同的部位，不同的脏器，发生不同的病变。这个咱们等学习完这几条以后再做一个讨论。

下边是小结：患伤寒六七天的时间，不但发生了结胸证，而且里热实证也较为明显，如果症状表现为“脉沉而紧，心下痛，按之石硬者”，为大陷胸汤主治之证。

伤寒十余日、热结在里、复往来寒热者、与大柴胡汤、
但结胸无大热、无大热者·此为水结在胸胁也·但头微汗出者、大陷胸
汤主之、①②（136）

注：

1. 《宋本》此条文如下：

伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤。但结胸，无大热者，此为水结在胸胁也。但头微汗出者，大陷胸汤主之。

2. 《宋本》此处有大柴胡汤方及方后注，此从略。

胡希恕：他说，伤寒十余天的时候，一般说的都已经传里了，已经热结在里，复往来寒热者，但反而还有往来寒热，一阵冷一阵热，这说明少阳阳明并病，虽然热结于里了，但还有半表半里证，这就是少阳阳明并病，阳明病已经发现了，少阳病还存在，所以他与大柴胡汤。但结胸，无大热者，那么，但结胸，结胸他这个热结于里，外面他不现什么往来寒热了，无大热这句话啊，那么有两种看法，一种无大热就是外无大热，就是无表热的意思，往来寒热仍然外有热，但结胸，这个整个结于里，外不现大热，但是并不是不热，不象表证的那个大热，半表半里、往来寒热的那个热，不是不能说没有热。此为水结在胸胁也，为什么他这个热外面不现呢？他胸胁有水结在那个地方，他气不得旁达，所以只是脑袋微微出汗，这个热从里往上冲，他不能往旁边散，他水结在胸胁，那么这是结胸证的必然的一个证候了，所以也得用大陷胸汤主治，这个注家呢，他这个说是水结在胸胁，上边是结胸热实，所以分开了，上一条说的是热结胸，这一条说的是水结胸，他是错了，这两段是相互反映的，头一段说是热结于里，结胸热实，结胸没有不热实的，不热实怎么能用大黄、芒硝那么大的量呢，那么这段呢，特别提出水来，那个热实也结胸，也是水结在胸下，那么这一段水结胸下，也是热结于里，一样的，用这两条把这个结胸证说得非常清楚了，不是说这个是水结胸，那个是热结胸，那是错的，那是片面看问题了，不对。大柴胡汤方，这个前面有了，应该有大黄，他这个没有大黄，错了，他这个方后也说了，他说，一方加大黄二两，若不加，恐不名大柴胡汤，大柴胡汤主要有大黄，这个没搁，那么这一段呢，他还有一个意思，就是大柴胡汤与大陷胸汤一个鉴别点，大

柴胡汤是必有柴胡证，那么这个结胸呢，结胸是外边没有往来寒热，同时没有柴胡证，结胸与胸胁苦满是绝对不同的，后面还要讲的，这个柴胡证呢，胸胁苦满，两胁特别的清楚，这个结胸证呢，是中间，心下硬满，甚至及于腹，当然胸也满，他必陷于胸下，所以在上一节按之石硬，这与大柴胡汤证都不一样，可是把这两条同时搁到这个地方，不但病的出入有关系，也让你容易鉴别，你别拿大陷胸汤证当大柴胡汤证，也不要拿大柴胡汤证当结胸证，那错了是不行的，大柴胡汤证前面讲的很清楚，也有心下急，心下急不等于心下痛，他不痛，而且也没有石硬，那个急，咱们讲过了，就觉得这个地方发窄，就是不宽大，它与这个心下石硬是不同的，临床上要注意，错了是不行的，大陷胸汤证当成大柴胡汤证那问题不大，要是大柴胡汤证当作大陷胸汤证就不行了，那就治坏了。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边是顶格条文。

《宋本》条文的后边有大柴胡汤方和方后注，《康平本》没有。下边解读一下：

“伤寒十余日”，也就是说患伤寒日期时日已经挺多的了，暗含着疾病有发展变化的可能。

“热结在里”，跟上个条文论述有点相似，但是内容不一样，方式相似。“热结在里”，这也是典型的经方病理辨证这方面的论述。就是指的发生了里实热证，言外之意应该有里实热证相应的一些症状存在。像大便不通，腹痛拒按这一类的症状。再去参照一些脉象、舌象都应该有这一类的证据存在。

但是，“复往来寒热”，同时存在着往来寒热，这是典型的少阳病的症状反应。一方面有“热结在里”，就是阳明病的证候了，同时又有少阳病的证，这就是少阳与阳明合病。应该是典型的大柴胡汤证，所以这里说“与大柴胡汤”。

这里重点论述的是大陷胸汤证，顺便跟大柴胡汤做了一个鉴别，

其实古人在当时这种论述方式是比较常见的，就是一石二鸟甚至一石多鸟，他要用最少的文字去论述最多的问题。

这里边还暗含着治疗原则。一旦少阳病和阳明病同时发病的时候，就不能单纯的去治阳明病，一定要以少阳病为主。大家看看大柴胡汤的方剂组成也能看出来，应该还是以少阳病为主，兼去里实。

下边“但结胸无大热”，在这应该理解为：患者只是以结胸证为主要的症状反应，“但结胸”嘛。没有，没有什么？没有里热或者少阳病造成体温升高比较严重的那种情况。换一个说法，既没有少阳病又没有里实热证非常重的像大承气汤之类的一类的疾病。这儿“无大热”也是一个排除法。

大柴胡汤证，有时候会表现高热，有时候会表现往来寒热，但有时候也没有热，体温并不升高。

这个地方实际上提示你去鉴别其他的，仅仅一个“身无大热”，要是单扣字眼的话，说明不了太多的问题。按照经方的理论真正进来以后，你再去举一反三地去想，什么情况下会有大热啊？表证有可能会大热，半表半里证、里实热证都可能会出现。你去找啊，有没有那一类的症状存在。

旁注“无大热者，此为水结在胸胁也”。那么在这个地方加的旁注，还是比较恰当的。进一步地明确了“无大热”的病理基础就是水结在胸胁。

“但头微汗出”，一方面虽然有里热，但是里热并不是十分严重，达不到大汗出的那种程度；另一方面，有水结在里边，也会影响到汗出不畅。这个病人就只是表现为头部“微汗出”，其他的地方没有汗。仅从字面上看，这个条文似乎论述的有关大陷胸汤证的症状并不多，但是，实际上都隐含在言外了。

“热结在里”，就包括了大多数阳明里热的一些症状。实际上这个地方讨论的是什么呢？是在大陷胸汤证的病理状态下，以阳明里实热

证的症状反应为重点的这么一种疾病。但是，跟真正的阳明里实热的区别在哪啊？它没有很明显的热象，这个热象不是病理方面的热象，而是“无大热”嘛。就是没有比较明显的体温升高的这种情况。这样回过头来再看啊，“但头微汗出”，“但结胸无大热”，实际上包括了所有的结胸证的症状反应，都有可能存在这种意思。

“但结胸”是什么意思啊？可能有结胸证的所有的症状存在，这里边实际上本身就涉及了一大堆的症状，这儿就等于说是简述了。这个条文里边另外的一层意思，在论述了大陷胸汤证的同时，还把大陷胸汤证和大柴胡汤证做一个鉴别。它们的鉴别点：大柴胡汤证有明显的少阳证，但是大陷胸汤证没有，绝对不应该有少阳证的。

尽管在临床当中，真正的大陷胸汤证的部位，常常跟柴胡证的部位有些基本上都相同。胸部的一些症状，腹部的一些症状，大柴胡汤证也都有。而且大柴胡汤证胸部应该说也是有所结，少阳病不就是嘛，里也有所结，但是这结呢，跟大陷胸汤证有质的不同。一个是热与水，一个是少阳病，再就是热与食。实际上症状反应也是不同的。但是用文字的方式要是把它论述清楚，再把它的细节论述清楚，还是一个不容易的事。但是把大柴胡汤放在这，让你去加以鉴别。

下面做个小结：

患伤寒十多天的时间，发生了里实热证，如果同时又有往来寒热的症状，可用大柴胡汤治疗；若仅仅是表现为结胸证的症状反应，又无大热，这是热与水结于胸胁，如果仅是头部有微汗出的则为大陷胸汤主治之证。

大阳病、重发汗而复下之、不大便五六日、舌上燥而渴、日晡所小有潮热、发心胸大烦^①、从心下、至少腹、硬满而

痛、不可近者、大陷胸汤主之、（137）少结胸者②、正在心下、按之则痛、脉浮滑者、小陷胸汤主之、（138）

注：

1. 《宋本》无“发心胸大烦”五字。
2. “少结胸者”《宋本》作“小结胸病”。

黄连一两 半夏半升洗 栝蒌实一枚大者

右三味、以水六升、先煮栝蒌实①、取三升、去滓、内诸药、煮取二升、去滓，分温三服、

注：《宋本》无“实”字。

胡希恕：本来是病在表，伤寒也不能重发汗，这个重发汗也是发错了，比方说，是桂枝汤证用了麻黄汤了，或者用大青龙汤这都错了，重发汗，那么重发汗这个病常常不解，所以太阳病应该微微似汗出才能好，假设大汗流离，病必不解，病不解，是桂枝汤证用桂枝汤不能用泻药，而复下之，这也说明是个错误，一再治疗上是有问题的，那由于津液亡失，尤其这个复下，表证复下，病必陷于里，亡失津液，胃中的水分也被夺，所以不大便五六日，胃中的水分也被夺，他大便就要干，五六天不大便，那么舌上燥而渴，津液虚了，所以舌上燥而且渴，那么不大便五六天，舌上燥而渴，这说明是陷入阳明病了，阳明病应该发烧，他仅仅日晡所小有潮热，稍稍有一点，什么道理呢，就上面这个结胸证，水结在胸胁，外面不会大热的，从心下至少腹硬满而痛不可近者，实是相当实了，从心下到小腹这个地方统统硬满，不可触近，你稍稍的手接近，他就疼的不得了，那么这样的实，一定是大发潮热的，唯独在结胸证不，小有潮热而已，所以这个也肯定是结胸证，大陷胸汤主之，这个是个重症的，他这个结的面太大了，从心下到少腹全硬满而痛不可近，疼得也剧烈，结的面也相当大，那么到这个地方，这个大结胸证差不多就是从各方面都说明了。

那么还有一种小结胸，这个小结胸病正在心下，也痛，这个《玉函经》是，小结胸者，这个者也行，病也行，没什么大问题，那么这个小结胸与大结胸就不一样了，他这个面结的非常的小，正在心下，就在这个胃部一点点，不象大结胸面积大，这个结的也不那么深，不那么重，所以按之才痛，你不按他不痛，脉浮滑者，你看这个有个浮，他这个病结的比较浅，所以脉还浮而且滑，那么前面讲了，脉浮大者，下之死，就是小结胸，就是有结胸也是小结胸，小结胸用大陷胸汤那是不行的，那有下利不止而死亡的可能。那么这个病既轻这个药也不能重用，所以他用小陷胸汤，小陷胸汤和大陷胸汤是截然不同的，我们看这个药，黄连、半夏、瓜蒌实，瓜蒌实这个药，它是一个大量用也多少有点解凝宽下，但是它这个不是大下，所以这个量也特别重，这个半夏呢，是祛水的，这个瓜蒌实啊，那么后来有的变成瓜蒌仁错了，这个实是果实的实，就是整个的，就是咱们现在用的全瓜蒌，他用一个，一个量很大了，这个大瓜蒌一个啊，那起码也有好几两，这个黄连与瓜蒌都是苦寒，祛热，解凝祛热，半夏祛水，这个大陷胸汤也是用苦寒泻热，用甘遂祛水，可是半夏不等于甘遂，半夏没那么大毒，也是个毒药，但是它这个常用的药不是那么毒，而这个黄连、瓜蒌实只是能解凝润下而已，不是那么一个大泻下的，所以这个药轻得很，也祛热逐水，但是比大陷胸汤，这个力量是不同了，这个小陷胸汤的药也常用，所以咱们治这个咳喘有时候宽胸祛痰可以用，但是也得有热，没有热是不能用的，这个药都是常用的药，很好，但是瓜蒌要注意，不要用几钱是一点用都没有，我们经常用的，我常用的都是一两半，就是四十五克，少用效果不大。这个小结胸病，结的面小，病邪也较轻，结的程度也比较浅，所以用的药也是轻药，只是祛热逐水而已。

李冠杰：这两条在《康平本》是一条内容，在《宋本》里把它分成两条了。我们把它当做一条来学习，但是也分成两部分，还是有道

理的。

先看第 137 条，这个条文里“发心胸大烦”五个字，《宋本》里没有，我们在学条文的时候再作进一步的讨论。

下边解读一下：

“太阳病重发汗，而复下之”。“太阳病重发汗”本身就已经属于误治了，见病不好又用了泻下的方法，这就是错上加错了。它结果就会对人体产生比较严重的影响。实际上这个地方重在说因为误治对人体产生了比较严重的损害。

发生了什么情况呢？“不大便五六日”。这儿讨论了一种误汗、误下以后，不单单没有出现下利不止，反而是出现了多日不大便。具体到临床中，服了泻下的药后应该会有大便泻下，泻完了以后，再就不解了这种情况。这是常见的问题啊，如果治疗的不对，或者治疗时出现了下利，如果用的方子对，它下利会止住。止住以后，它可能会两三天没有大便，这也是正常的。这个地方不是那种情况，就是说服了泻下药以后肯定有大便，但是泻完了以后大便就不解了。人体实际上就偏于发生了里实热证。

泻下的方剂怎么会这样？经方里说过好多次了，就是那个丸剂、丸药，巴豆剂这一类的。巴豆本身是一个温性的泻下药，再加上前边已经发过汗了，本来就有里热的倾向，再用热性的温性的泻下药，就很容易造成里热比较严重，最终形成里实热证。

从这我们也能看出，经方里论述误治，有的是服了泻下药以后“下利不止”；有的是服了泻下药以后，病反倒是“阴阳自和，必自愈”。这儿讨论的是另一种情况，就是说发了汗，又泻下以后出现了里实热证，反倒是不下利了。为什么这样？除了治疗方剂是巴豆剂之外，还有人体的体质问题，再一个就是那个发汗具体发的是什么样的情况等等的因素，都很多。这不是论述的重点，我们学习呢应该有这方面的体悟。

“舌上燥而渴，日晡所小有潮热”。误汗以后再误下，这个发汗本身是重发汗，发汗太多了，人的体液损耗比较大。另一方面再误下的话，对体液的损耗进一步的加剧。这儿呢又产生了里热，里热又会加速体液的损耗。这个时候病人的反应就比较强烈一些，就会出现“口干舌燥又渴”的状态。“日晡所小有潮热”是典型的阳明里热的症状反应，这个“小有”是说程度并不是特别的重。虽然说程度不很重，它依然能够把疾病的性质给反应出来，这是出现阳明里热了。为什么说潮热不是特别重呀？前边的条文里已经说到了这类的意思：因为它里边有水结的问题。

“发心胸大烦”，这一句话在《宋本》里给删掉了，原因我们现在无从知晓。这个《宋本》和《康平本》，我们仔细的去揣摩它，你会发现自从张仲景写完了《伤寒论》以后就失散了，再发现时，所有介入这本书的人态度都非常严谨。明明在条文中间的五个大字肯定不是丢失，应该是有意的删掉了。为什么删掉呢？真正的原因现在难以下一个确切的定论。但是我们从条文的内容看，很可能整理者认为：这个条文论述的是以腹证为症状反应的一种大陷胸汤证，它会出现这么严重的胸部症状吗？他可能会有这样的疑问。这个“心胸大烦”再加上整个腹部痛的都不可近，那还了得呀！结果有可能就把这五个字给删掉了。咱们现在就这么揣摩，很难说清真实的原因了。

我们今天再来审视一下，应该不应该有这类的症状。从这个方证的病理上来分析，这就是一个热与水结于胸胁，出现胸部的症状应该是一个很自然的事；再从条文所论述的症状表现来看，整个腹部都那么难受，再加上有水 and 热结，恐怕胸部也有水结的情况，这个时候有可能出现心烦、胸部的一些不适啊，像这个论述的实际上是个什么病呀？像我们今天说的腹膜炎这类的疾病，整个腹部都发炎呐，它肯定对胸部也会有影响的，至少它可以上迫胸膈膜这儿，如果这个病机上就有胸部停饮的情况，胸部有比较明显的不适感应该是正常的事，总

觉得不应该把它删了去。

下边“从心下至少腹硬满而痛，不可近者”。咱们刚才说了，看看这是一种什么样的症状呢？“心下”就是胃部，“少腹”就是小腹部，从胃部一直到少腹不单单是硬、满，而且还疼，疼到“不可近”。这个“不可近”，郝万山老师就讲了这个问题：学生们听说了病房里有一个这样的病人，都去要看看，体验体验，后来发展到那个病人只要听到门一响，一看到医生来了，就吓得不得了。就是说他拒按的敏感度非常高，程度也非常重。实际上这个就类似于现代医学的腹膜炎之类的疾病。

这一段条文它论述的是在结胸证的基础上，因为里实热证严重，而且又发生了以腹部硬痛拒按为主要症状反应的一种情况。虽然说主要症状表现为腹部，但是病理仍然是结胸证，就是说“水与热结于胸胁”嘛。所以说在这种情况下出现胸部的一些症状很正常。刚才咱们也说了“发心胸大烦”这个证应该有的。

下边看看第 138 条：

“少结胸者，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之”。这条在《康平本》里也是一个顶格的条文，但是《宋本》里“少结胸者”改成了“小结胸病”，这里边也没有太大的问题。

这个“少结胸者”，它反映出经方理论对疾病的界定和划分明显的与其它的医学不同。从小陷胸汤的症状反应和治疗方剂上看，它跟大陷胸汤证有着很大的区别。如果用经方的病理辨证体系来辨证，它们之间又存在着密切的关联，病理上分析这两个方剂都属于热与水结于胸胁这类的情况。但是疾病的症状反应无论是从程度上也好，还是从部位上也好，都有着明显的差异。所以这儿就给了一个“少结胸者”。

在其它的医学里，像治疗方法完全不一样，把它算成一类疾病恐怕不太合适。但是在经方里，跟这个症状反应比较接近的，刚才说的大柴胡汤，大柴胡汤证那个“无大热”，也包括了一个就是像承气汤

证。这些方证和症状反应，和大陷胸汤证的症状反应有时候就比较接近。所以好多书在方证的鉴别方面，常常把大陷胸汤证和大承气汤证放在一块儿，有的也和大柴胡汤证放在一块儿做一个鉴别，就是因为它比较接近。但是比较接近的那一类它没叫成结胸，而单独的把小陷胸汤证的症状反应叫做结胸，实际上它反倒是比大陷胸汤证和大承气汤证之间的症状反应差距要大。就是因为它们在病理上关联比较密切。

“正在心下，按之则痛”，这是小陷胸汤证的一个典型的症状反应。“正在心下”按字面理解，一般会理解成正好是在胃的部位，但是实际临床中，小陷胸汤证的这个“心下疼痛”常常集中在胃部的偏上，就是鸠尾穴附近这一块的位置，有时候还会上延至胸部。因为瓜蒌本身就有治胸部疾病的一些功能，所以有时候会有一些胸部的症状。“按之则痛”，是在疼痛的程度上明显地有别于大陷胸汤证的情况。大陷胸汤证是“从心下至少腹、硬满而痛、不可近”，那个程度多么重啊！虽然临床中小陷胸汤证也有不按它也疼的情况，有的时候病人主诉说胸口这个地方疼，但是大部分表现为不摠就没有明显的疼痛感，只有腹诊的时候按压一下，才有比较明显疼痛感；或者稍微有一点疼痛感，按压的时候疼痛感会加重。这儿用了“按之则痛”，也非常恰如其分地描述了小陷胸汤证的临床特征。

跟“正在心下，按之则痛”比较接近的是大柴胡汤证。大柴胡汤证是“心下按之满痛”，多了一个“满”，这也很重要，因为是有里实，所以摠的时候，病人会觉得里边不单单觉得疼，而且有满的感觉。这是临床腹诊过程中应该经常注意到的事，去区别这些病人的感觉和医者手下的感觉。

“脉浮滑”，浮脉在这个地方就不是表证的应征了，是小陷胸汤证。它候的是小陷胸汤证所结的部位偏浅和偏上的一种情况；滑脉在这个地方候热，就是有热。实际临床中，小陷胸汤证现这个脉象可能

是比较多，但这不是唯一的脉象，临床统计资料里还有沉脉、微脉、细脉等等。

下面做个小结：本为太阳病，但是医者发汗太过，见病不愈，又施以泻下的方法，致使患者五六日不大便，舌上燥而渴，日晡所小有潮热，发心胸大烦，从心下至少腹，硬满而痛，不可近者，为大陷胸汤主治之证；如果是小结胸者，则表现为正在心下按之则痛，脉浮滑的，为小陷胸汤主治之证。

来看看小陷胸汤的方剂，一共就三味药：“黄连一两、半夏半升、栝蒌实一枚大者”。栝蒌实是指的全栝蒌而不是栝蒌子。方剂中的黄连去半表半里之热，半夏去水降逆，栝蒌是方剂中的一个主药，用量也比较大，栝蒌是一味寒性的药物，它有解凝、缓下、去水、清热的功能，特别有作用于热结于胸或者上腹部的这类疾病，它和薤白合用，专门用来治疗胸部疼痛。方剂中栝蒌用量写的是“一枚大者”，实际临床经验看，栝蒌用量宜大不宜小，如果用量偏小了，它作用就不太明显了。我查了一些资料，有的资料说栝蒌一枚是 46 克，这肯定是指的干的，不是鲜品，实际量应该还要大一些。如果它是 46 克的话，半升半夏应该是 65 克左右，这一枚大的栝蒌还不如半升半夏的分量大呢，这跟实际临床不符。胡老的经验用量是这样的：黄连 6 克，半夏 15 克，栝蒌是 30~60 克，这个量就比较大了，胡老这个量，除了他临床经验以外，还有一个这是与经方的实际用量是相通的。

如果手头上有栝蒌这个事就好办了，但是现在进的药都是切了的。我也从切了的栝蒌里边，把那些完整的凑了十来条称了称，大概应该是五六十克的样子。后来我觉得还是不踏实，今天中午吃完饭以后，正好碰到一个老中医，我就问他有整个的栝蒌吗？他说现在进的都是切好的，我说我想把栝蒌的分量核对一下。他说胡同南边有一个体育场，那地方长着一些栝蒌，咱们去看看就行。到那以后，整个一面墙上，挂的就跟小灯笼一样，一串一串的全是栝蒌，我们俩就拣干

的比较重的摘，我找了干得挺透的最大的一个。听附近的住户说这是野生的，今年长得还不如去年大，另外还有一个干得很透很瘪的，觉得干得很透，我拿到那诊所里称了一下，那个干的发瘪的明显看着小一点，是 60 克，那个大的称了称是 102 克，它肯定多少还有一点水分，干得不是很透，要把水分去去，最起码也得七八十克的样子。这样就跟胡老这个用量基本上就能吻合了。

这里边还有一个问题，其实要放到实际临床上来想象经方标的量，一枚而且是大者。为什么不论量呢？因为往往会找到鲜品，如果找到的觉得不是很大，手头上没有很大的怎么办呀？用一个半行不行啊？甚至再小一点，两个行不行？如果这样想的话，就比较好理解了。我找的这个大的还要放一段时间，让它水分干一干以后再称称。再想象一下，我今年这个算小一点的话，大个的应该在一百来克。还有另外一个资料说是 130 克，不知道这个数据怎么来的了，也许真有大的能够达到这个量。但是这儿反映一个事，中医这个药量方面，应该有一套比较让人能够信服的、通用的数据才对，这是关于栝蒌的用量。

另外，从方剂的药物组成上看，虽然这个方子所对应的病理状态跟大陷胸汤证基本一致，但是这两个方剂所用的药物没有一味是相同的，而且在临床的症状反应其实差异也比较大，我们在四诊过程中能看到的差别也是很明显的，那么我们怎么理解呢？应该理解这两种疾病之间还存在着深层次的差异，尽管病理接近，症状的部位也相似，但是它还有深层次的不同，因为它用的药一点都不一样。差在哪儿？这实际上是有待于进一步研究的东西，而且需要我们在临床中去体悟的东西。我这段时间在考虑一些这类的事，比如茯苓和白术（苍术也好，白术也好，都一样）这两味药，其它的像猪苓、泽泻，都是祛水的药，但是它们有一些功能明显有所差异：比如白术它在祛水的同时，还能治疗像肢体的疼痛、风湿病这类的；但是要用泽泻就办不了这个事。它们肯定在药理上有很多的差异，虽然都是祛水的，但它肯定存

在着质的区别。这个区别恐怕不是我们所能解决了的，但是我们在临床中应该去体悟什么？假设说一个白术证和一个泽泻证，这两味药的药证，有没有明显的、有代表性的区别？这是我们在临床中应该关注的东西，关注多了以后，你的用药逐渐就能够达到丝丝入扣的程度，不至于说一见到停水，就一大堆利尿的药下去，往往效果不好。

下边是小陷胸汤证临床的方证和对应的现代病

小陷胸汤方证（共 367 例）

症状：脘腹痛 219，发热 153，便秘 150，食欲不振 124，脘腹胀满 123，胸腹胀闷 56，呕吐 54，尿黄 53，胸痛 51，咳嗽 50，喘促 49，咳痰 48，口渴 48，口苦 36，烦躁 31，恶心 31，头痛 24，神疲乏力 21，失眠 18，便溏 16。

舌质（158）：红 145（尖红、暗红、红降），紫褐 8，淡 5。

舌苔（198）：黄 144（黄、黄腻）、白 45（白腻、薄白）、无苔、黑垢、浊干、焦黄起刺。

脉象（224）：滑 152、数 117、弦 80、浮 39、微弱、沉、细、濡。

小陷胸汤的现代应用：急性胃炎、十二指肠溃疡、十二指肠炎、肠蛔虫症、粘连性肠梗阻、胃肠神经官能症、胆道蛔虫、梗阻性黄疸、慢性胆囊炎、急性肝炎、肝硬化腹水、急性胰腺炎、副伤寒、急慢性支气管炎、支气管扩张、支气管肺炎、肺不张、肺气肿、肺炎、胸膜炎、渗出性胸膜炎、胸膜粘连、冠心病、心绞痛、心肌梗死、肺心病、精神分裂症、植物神经功能紊乱、肋间神经痛、急性乳腺炎、乳腺增生、食道炎、食道憩室、慢性胃炎、急性胆囊炎、慢性肝炎、流行性出血热、肾炎、腹膜炎、淋巴结核。

我们再通过上边的条文学习做一个延伸，就说我们学习过了第 134、第 135，一直到第 138 这些条文以后，我们会发现一个问题：既然是这几段都是主要论述的大陷胸汤证，为什么它不把所有的大陷

胸汤证的典型症状集中在一条里做一个很全面的论述呢？古人采用的这种论述方式看着比较散，但实际上这种论述方式恰恰反映了人体患病以后的复杂性。就以大陷胸汤证为例子吧，它的病理是“热与水结”。同样是在一个病理状态下，它表现在不同的人体上会发生在不同的部位、不同的器官，甚至完全不同的病变性质。怎么说是同一个病理状态下？因为都需要用这个方剂来治疗。我们刚才说了柴胡证是最明显的，特别是小柴胡汤、大柴胡汤那是最明显的。

临床统计资料就给我们提供了这么一种分析的基础，它用多条条文来论述，就是提示读者在相同的病理状态下，它会存在不同的症状反应的重点，重点的症状反应不同，它为什么都把它分开说？实际上用今天现代医学的眼光看，这是不同的病，它呢也在面对这一个现实。但放到经方理论里这应该算是一个病，它就是一种病理状态，用一个方子治的。但是它确确实实发生的病变的性质和病变的部位又不一样。这样它就分开论述，从这个角度再看，它也非常体贴读者，要揽到一块儿去论述，反而抓不住重点了。而且今天用经方，有的人就喜欢套条文嘛，它有没有这个证？它是这个方证吗？反倒是不好用也不好理解。这是通过学习以上条文延伸出的一个点。

另外一点，这个条文中提到了：“结胸热实，热结在里”。“热实”是热证、实证，“热结在里”是热证、里证，“结”就是说热和里它有了实的性质。我们如果把目光再展得宽一点，像小青龙汤证的“心下有水气”，像抵挡汤证的“下血乃愈”，像那种“必有蓄血”等等这类的论述，它都明明白白的反映了这就是经方病理辨证体系之内的一些东西。换句话说，实际上经方整个的辨证体系，在成书的时候都已经非常完备了，只是说它的论述方式跟今天的论述方式不一样，它不能用过多的语言去把这些东西给你理得特别清。但是它在条文里面都已经说了，你自己应该去归纳总结。

可是事实上，就是因为这类的论述方式，让人不好去归纳、总结

它们之间的一些内在联系和隐含在里边的一些具体的病理方面的东西，它不是症状。这些东西后世有没有总结？有总结！最浅的总结就是六经辨证，因为它这六个题目就分了这么六大类。很明显的大家都在总结。古今一直在这么说六经辨证，甚至把它理解成经络，大家看看刚才说的跟经络何干呐？像这个结胸热实、热结在里，包括“心下有水气”，这些东西经络能概括得了吗？六经就是分了这么几大部分，把常见病分成六大类，它方便论述，而且它确确实实它有一个纲的作用，但是有了纲不等于有了目，它只是疾病类型的一大部分，还没有全部包括，其它的在条文里面都有。

后世再进一步的总结就总结成一个“八纲辨证”。其实我们现在跟大家提示了以后，大家有没有这种想法：本来“经方辨证”就是一个非常全面、非常完整的体系，为什么非得要用“六经辨证”或者“八纲辨证”这种某个数字一下子把它限制住？把一个本来非常全面、完整的辨证体系弄得支离破碎？就说“八纲辨证”上面这些东西，比如说“心下有水气”、“必有蓄血”，像这类东西“八纲辨证”里它也没有啊。本来经方理论里有这些东西，但是你总结的不全，不全咱们把它补充全了不就行了嘛！为什么老是固守着这些东西呢！除了我现在见到的胡老有这方面的探索，还有一个山西的老中医李翰卿在这方面也有比较有益的探索，他的观点就说辨证必须去辨这些因素，但是他的不足是把“寒热、虚实、表、里、半表半里”这些因素都集中到他的辨证体系里，但是他同时又有“脏腑辨证”，等于说这是他的一个不太科学的地方。因为你去辨这一套东西，再去看看临床统计资料，“脏腑辨证”它实际上只是反映了疾病的一个方面，它反映的不是疾病的本质，只有经方理论的这些病理辨证要素反映的才是疾病的本质。

所以说，就是因为对经方理论的片面总结、片面理解，到最后形成了一个历代医家都把经方理论奉为经典，但是临床中却很少有人真

正用经方去治病这么一种局面。今天学习的环境改善，社会信息畅通，让我们接触到了胡老的学术思想，确确实实胡老给我们树立了一面旗帜，我们应该沿着他的方向，继续的往前探索，把经方医学发扬光大。

大阳病二三日、不能卧、但欲起、心下必结、脉微弱者、
此本有寒饮也①·反下之、若利止、必作结胸、未止者，四五日复
下之②、此作协热利也、（139）

注：

1. “此本有寒饮也”《宋本》作“此本有寒分也”。
2. “四五日复下之”《宋本》作“四日复下之”。

胡希恕：四日复下之，《医宗金鉴》改作复下利，我认为这是对的，复下之也当下利讲也可以的，不是再吃泻药，没有这种大夫，下利不止还给吃泻药，太阳病在二三日的时候，一般说不传里，那么这个人，不能卧，但欲起，不能卧，但欲起大概都是气短，喘，那么小青龙汤证就是那样的，咳逆倚息不得卧，靠着东西坐着，他里头要是停水他是怎样的，水就下，你要是坐着，这个水往底下去，沉于下，一躺下就往上压横膈膜要喘、短气，那这个病人呢，他是不能卧，但欲起，这肯定要两种问题，一个说心下有所结，阳明病里实也能压得喘，要不咱们现在治喘，每每用下药，他里实，使横膈膜上下运动发生障碍，他也要喘的，以腹满而喘，凡是不能卧，但欲起者，他心下一定有东西，为结，有东西是两个问题了，一个是实，一个是有水，那这要看他脉吧，要是实，脉沉紧，或者是沉滑沉大那种的，他脉微弱，不是那么实，实在的实，可见就是水，所以他说，此本有寒分也，那么在心下部这个地方啊，他是有水的成分在，所以他的脉不那么实、不那么大，而微弱，反下之，这个有水饮的不能吃泻药的，若利止，假设说吃泻药之后不利了，那就说明他不但有水，也是有热了，必作

结胸。未止者，这个下利不止，二三日吃的泻药到第四天还继续下利，此作协热利也，不能结胸了，水协同泻药而为下利，协热利是古人对热利的一种名称，协热也叫夹热，就是表的热协同下利起而为利，叫协热利，也叫夹热利，这种利夹热，没有热，这种利就好了，头前的葛根芩连汤就是这样，去热下利就止。反复说了，里头只是热没有水，不会结胸，又有热又有水容易结胸，不结胸，水由于泻药的关系，加上协热利不止，叫协热利，这个协热利提出来与上面提出黄疸是一样的，都是借这个说明结胸证是由于热造成的。

李冠杰：这个条文呢，在《康平本》里边是一个顶格的条文。

这个旁注“此本有寒饮也”在《宋本》里边呢，是“此本有寒分也”，这里有一字之差。“四五日复下之”在《宋本》里边呢，是“四日复下之”，没有那个“五”字。

下边我们呢解读一下：

“太阳病二三日”，也就是说初得太阳病不久，但是呢却发生了后边所论述的一系列的症状反应，说明什么？说明病势比较重。

“不能卧，但欲起”，这是一种由于腹满所造成的这么一种症状。患者平卧的时候，腹满上迫，影响正常的呼吸。坐起来以后，因为重力作用，不管哪一类的腹满，坐着比躺着觉得会减轻一些症状。所以病人老愿意坐着，躺下他就难受。

这儿也作了一个病理的解释，就是“心下必结”，也就是说心下有所结。那么是什么样的性质的结实呢？这一类的情况，里饮证和里实证都有可能出现，所以就要进一步地加以辨证。

在这个条文里边，用了一个具体的脉象来佐证，就是“脉微弱者”。这就说明这个证是由于里饮证所致。要如果是里实证的话，脉象可能会呈现沉紧或者沉实有力等这一类的脉象，不会是那个“微弱”的脉。再结合临床实践的话，这个条文当中的“脉微弱”，就只是给读者一个提示，如果是有停饮的话，也未必就准是一个“微弱”的脉，也不

一定。但是这个地方呢，就给我们提示了一个辨证的方向，你再进一步地去找其他的证据。比如舌象、腹诊、望诊、二便，这个都可以去找。看看他到底是什么原因？因为腹满到这种程度，至少里实证和里饮证都有可能。

旁注的作者在这儿作了进一步地解释：“此本有寒饮也”。就是患了太阳病才两三天的时间，就发生了这个证，说明患者本来就存在着停饮的这种情况。

这个条文论述的就是误下以前，既有表证又有比较严重的里饮证的这么一种情况。患了两三天的表证，之所以这么重的病情，就跟他患表证之前，就可能存在水饮的这种倾向有关系。这一类的情况，比较类似于小青龙汤的症状反应。

“反下之”，那肯定是误治了，表证不可下，里饮呢，就更不可下，所以这儿说“反下之”。

“若利止，必作结胸”，这个地方论述的，就是上边所说的这些情况，会造成什么样的结果呢？这个地方论述了两种结果：“若利止，必作结胸”是第一种，就是服了泻下药以后，虽然有过下利，但是很快就能够自行停止了；像这种情况，这么重的水饮再误下，就有可能发生结胸证。

那么“未止者，四五日复下之，此作协热利也”，这儿论述的是误下以后，可能出现的第二种情况。就是下后，下利没有能够自止，这么一种情况。

这个条文里边我们要仔细看啊，胡老那个讲解里边，也谈到了这一点。这儿条文里边出现了一个逻辑上的问题：既然是误下以后，下利还没有止，为什么还会在过了四五天以后，又施下法？胡老说法呢，就是没有这么傻的医生。他在这儿一直拉着肚子，你还让他吃泻下药吗？但是按着《医宗金鉴》的解释：此处的“复下之”应该是“复下利”，按着《医宗金鉴》的这种解释呢，再来看看原文大致是个什么

意思呢？就是说误下以后，下利一直没有自止，过了四五天之后又出现下利。实际上这儿，就出现了一个更为严重的逻辑上的问题。既然一直在“下利”，又怎么会出现“复下利”呢？下利得更厉害了，这个事好像也让人感觉到难以解释通。

那么到了这个点上，我们就不得不考虑另外一个因素。这个地方的原文，是不是本来就是一个不完整的？其实这这也是一个值得疑问的问题。

咱们现在已经学到了一百三十多条了，会发现很多这个事，这书有好多不太完整的地方。他缺了字，画上一个框或什么的，我们能看得很清楚。是不是有一些特殊情况下，当时他也看得不是很清楚，抄的时候就凭着他自己能够看清的那一部分，就把他抄下来了，也不一定没有这种情况。

实际上，距今已经将近两千年的这么一本书了，这是很正常的，这才应该是这个书的本来面目。要如果他一点问题都没有，到处都很通顺，也没有别人加工起来，那反倒是让人感觉到不可思议的，倒让人觉得不太真实。咱们就存疑。

那么我们今天学习啊，我们把学习的重点放在哪儿？就放在理解他的精神实质上，他到底要说些什么？我们从这个角度，我们再来看一看这个条文：“此作协热利也”。这是对此前论述的情况所作的一个病理解释。“四五日复下”也好，还是“复下利”也好。尽管我们现在已经没法把前边的文字确切得搞清了，但是有一个问题是绝对能够清楚的，就是下利不止，这点是准确无误的。

从这个意义上说，这个地方想说什么？在病理上定了一个性，在经方里边叫做“协热利”。我们如果再仔细看一看的话，这个地方的“协热利”，不是热性下利，这个地方论述的实际上是误下以后，出现的虚寒性的下利。虽然条文里边用了协热这么一个词，但是，这是古人对表证发展为里虚寒证下利的一种特殊的定义。因为这个条文里

没有具体的治疗方剂，是不是虚寒性下利，我们必须借助于其他条文来佐证。

《伤寒论》第 163 条：“太阳病，外证未除，而数下之，遂协热，而利下不止，心下痞硬，表里不解者，桂枝人参汤主之”。这个条文所论述的情况，跟咱们正在学的这个条文非常相似，也是表证误下。但是从治疗方剂来看，这明显就是误下以后，发生的里虚寒证，桂枝人参汤就是理中汤加上桂枝，那肯定就是虚寒性的下利。但是在条文里边却用了“遂协热，而利下不止”，这儿同样用了协热，跟我们这个条文里边是一样的。可见古人所说的协热利，不是一种热性下利，而是一种虚寒性的下利。

那么对热性下利，怎么说呢？第 32 条“太阳与阳明合病，必自下利者，葛根汤主之”，这才是一个热性下利，这类热性下利，他反倒没有用协热利这一类的字眼来论述它。

下边做一个小结：

太阳病初得二三天时间，便出现了不能卧，但欲起，如果心下有所结，而脉微弱的，这是里有寒饮的一种情况。但是医者反而用泻下的方法予以治疗，如果下利自行停止的，就可能发生结胸证；如果下利未能自止的，甚至四五日后又误下的，则为协热利。

大阳病下之、其脉促、不结胸者、此为欲解也·□□□□□

□^①、（140）

注：《宋本》无此六个缺字符号。

脉浮者、必结胸、脉紧者、必咽痛、脉弦者、必两胁拘急、脉细数者、头痛未止、脉沉紧者、必欲呕、脉沉滑者、协热利、脉浮滑者、必下血、（140）

胡希恕：下边这个要不得，此为欲解也，就完了，以下都是以脉定证，这个是不可靠的，如下者脉浮，就结胸没那事，头前讲了，脉浮者，此为在外，用桂枝汤，怎可以叫必结胸？所以底下可能王叔和加的，脉浮必结胸，结胸脉浮也是寸脉浮关脉沉，头前有，脉紧也不一定咽痛，当然是邪盛容易咽痛，但是不一定必咽痛，所以以脉定证靠不住，故底下的不管它。

太阳病宜汗不宜下，下为误治，其脉促，促脉就是寸浮，关以下沉，是结胸证的脉，此寸浮关沉一样的。有此脉而不结胸，说明促脉在这儿还是表不解。前面的葛根芩连汤就是，下之后脉促者表不解也，要结胸，促脉是结胸证的脉，如果不结胸，只是表不解而已，病没因泻下而变成坏病，所以不要紧，“此为欲解也”。下面的是以脉定证了，下后的各种变证可以为结胸为咽痛，为两胁拘急，就是少阳病了，也可是表不解，头还痛，也可以激动里水而呕吐也可为协热利，必下血是伤阴了，如邪热内陷，人以前就有瘀血的情形，是可以下血的，这个都可能，但不一定限于此脉浮必结胸等等，这靠不住的，中医的脉不是哪个脉就是哪个证，一个脉主多方面的证。所以在临床上，脉证必互参，才能明了。例如：女人有孕，2~3月脉要滑，阴搏阳别，滑脉主有孕，男人脉滑难道有孕？要结合实际，女人断经二三个月脉滑必有孕，不然的话也不一定有孕，故脉不能为哪一证，如脉浮就主表，但也主热，有表证脉浮就是有热，所以此书有病发热十余日，虽脉浮数者可下之，此脉浮数不是表证了，是里热。

李冠杰：“太阳病，下之，其脉促，不结胸者”，下边“此为欲解也”，是旁注内容。再往下是六个缺字符号。接下来是另起一段，“脉浮者，必结胸；脉紧者，必咽痛；脉弦者，必两胁拘急；脉细数者，头痛未止；脉沉紧者，必欲呕；脉沉滑者，协热利；脉浮滑者，必下血”。

这一段是降一字格的排版的条文，在《宋本》里边这两段合并成

了一段，实际上本身是两个自然段，但是内容应该是有一定的联系。条文里边第一段当中的六个缺字符号，在《宋本》里边是没有的。

这一条条文两段，我们分成两部分来学习。

第一部分，就是顶格这一块内容。“太阳病下之”这肯定就是误治了。

“其脉促”，关于促脉在之前的条文学习过程当中，咱们详细地讨论过了，实际上就是寸脉独浮的一种脉象。那么在这儿，应该是表证仍未解的一个证候。

“不结胸者”就是指没有结胸的症状。虽然有了这样的脉象，但是却没有结胸的症状。

因为后边的正文已经缺失了，所以我们不知道后边是还有其他的证啊？还是要给它一个定性啊？还是出了一个具体的治疗方剂呢？我们已经不得而知了，但现在仅能看到的这些文字，我们来理解这个条文。

这一条所论述的这种情况，跟第 21 条桂枝去芍药汤证比较相似，因为我们现在就见到这些文字。那段条文说：“太阳病下之后，脉促胸满者，桂枝去芍药汤主之”。这儿的不结胸，不等于说没有胸满证啊？脉象是一样的。这儿只说了一个不结胸，是不是还有别的症状？现在我们已经不得而知了。

当然这个促脉在第 34 条里面还有，那是葛根芩连汤证中，那儿有个“脉促者表不解也”。但是“脉促者表不解也”这七个字，是旁注内容。我们跟第 21 条联系起来的话，也有相通之处，都是指的寸脉独浮。寸脉独浮就是候表未解，这解释也挺明确，这是可以讲得通的。

旁注：“此为欲解也”，这个旁注加的毫无道理。像这一类的情况，在第 21 条里边，这里有一点，加旁注的这个人，他恐怕也是看到原文和我们今天看到原文内容是一样的，他也是觉得后边，有六个

字丢失了，那么他想说什么？那不是表证吗？仅仅是一个脉促，又不结胸，那不就快好了吗？他大概就是这么一个意思。但是这个地方“不结胸”，只是说没有结胸证而已，并不说明没有其他的症状。而且就仅凭这个促脉，也无法证明这个条文论述的是欲解的情况，因为他还有病态的脉象呢。那怎么叫“欲解”啊？在经方里边凡“欲解”，都是说没必要再治疗了。

第二部分：都是一些如果是什么样的脉象，就必然会出现什么样的症状，都是这一类的东西。

这个地方先说一个带有方向性的问题。无论这个条文的作者是谁，他这种论述的内容都不可取，不足为训。这个条文的作者为刚才有残缺的条文，就是前边顶格的条文，因为有残缺，他感觉应该作一个注解，他为那个条文作的一个补充。大致的意思就是说，太阳病如果误下之后，如果分别出现下边他所论述的各种脉象的话，那么就会出现他所论述的那种对应的症状。

条文里边出现频率比较高的一个字，我们今天必须弄清楚。就是条文里边的“必”字。他的本意大致有这么几个意思：一个是“一定”的意思，就是必然、必定、必须，还有一个必需，势必、未必，这一类的意思；第二个意思，是决定、肯定的意思；第三个意思，就是固执的意思；第四个意思是果真、假使这一类的意思。

在咱们学习《伤寒论》的过程当中，我们对这个字也讨论过好几次，严格地说，上边这些所有的解释还不能完全概括“必”字在《伤寒论》里边的本意。有一些地方用这个假使，放上比较合适。葛根汤证：太阳阳明合病，假使下利的，葛根汤主之。这个地方放上基本上意思就通，也比较贴合。要如果说一定下利，那就不通了，在临床当中葛根汤证不下利的有的是。但是在其他类似条文里边，用假使不是特别合适。

《伤寒论》里边有的地方，把这个“必”字解释成可能，反倒是

更客观，有时候呢可以当作如果来理解。但是在这个条文里边，几乎这些解释啊，放上去都不太合适。可能、假如、如果、假使，这一类的意思，要是代替这个“必”字的话，这个条文就变得不合逻辑了。因为后面没有治疗方法，这个“脉浮者”可能结胸，或者假使结胸，用某某方子来治，这个行，能通。用这个意思解释，解释不通。

那么用什么来解释非常的通啊，就是那个肯定的意思，必定、必然，用这个解释就非常通。但是，用这个来解释的话，这个条文跟临床实践就严重的脱轨了，这就是一个比较严重的问题了。无论从经方的理论论述中分析，还是从临床统计资料来看，都没有某种脉象必定会对应的某种症状的根据存在，没有这个根据存在。

实际上脉象就跟症状一样，除了比症状更客观一点之外，从性质上，跟症状没有任何区别。也就是患病以后的一种表现形式。仅凭一个脉象，根本就无法准确的确定治疗方剂，必须得是四诊合参。而且有时候还会舍脉从证，当然有时候也会有舍证从脉。

所以胡老对这一类的条文，就持严厉的批评的态度，这一类的东西根本就不科学。好多东西，都是很片面，跟临床实际也没法接轨。

这个条文，正文不完整，后边加的这些内容，又问题多多，咱们就不做小结了。

病在阳、应以汗解之、反以冷水渍之、若灌之、其热被劫不得去、弥更益烦、肉上粟起、意欲饮水、反少渴者^①、服文蛤散、若不差者、与五苓散、寒实结胸、无热证者、与三物小陷胸汤、（注）白散亦可服・（141）

注：“反少渴者”《宋本》作“反不渴者”、

文蛤散^①

注：《宋本》作“文蛤散方”。

文蛤五两

右一味、为散、以沸汤、和一方寸匕服、汤用五合、
白散^①

注：《宋本》作“白散方”。

桔梗三分 巴豆一分去皮去^①熬黑研如脂 贝母三分

注：“去皮去”《宋本》作“去皮心”。

右三味、为散、内巴豆、更于臼中杵之、以白饮和服、
强人半钱匕、羸者减之、病在膈上必吐、在膈下必利、不利
进热粥一杯、利过不止、进冷粥一杯、

五苓散^①

注：《宋本》作“五苓散方”并于其后有方及方后注，此从略。

身热、皮粟不解、欲引衣自覆者、若以水澀之洗之、益
令热劫不得出、当汗而不汗、则烦、假令汗出已、腹中痛、
与芍药三两如上法、

胡希恕：病在阳，也是病在表，依法当以汗解，反以冷水澀之，拿水喷脸为澀，或灌之，或者用水浇身，以凉水浇身，这是古人用冷水激之，让其出汗的法子，以水浇身为灌，无论用冷水澀其面或以冷水浇身，全能使表热被冷水所却而不得出，不能因汗而解除，“弥更益烦，肉上粟起”前面大青龙汤证讲了不汗出而烦躁者，此汗不得出故更烦了。由于热与水相激，起鸡皮疙瘩，就是小疹子，这也是不得汗出的表现，表证身上满水份要排出，借汗排除，而外面一激，故而发生此种疙瘩，热不得向外，意欲饮水，热不在胃肠内面，里面无热，所以反不渴，不象白虎汤证，后者热结于里了，故渴，此仍为表热不除，不汗出而烦躁，并不渴，所以应用文蛤汤，文蛤散是错的，以后介绍全匮要略就知道了。此方与大青龙汤就差桂枝与文蛤，把大

青龙汤的桂枝去掉加文蛤、麻黄减量，大青龙的麻黄六两，而此方是三两，因为在表其热被劫不得去，弥更益烦，与大青龙汤证差不多，就是不得汗出排热，而人更烦，还是无汗，那么就用麻黄加石膏这法子就对了，所以不用大青龙汤，表证没有大青龙汤证厉害，若不差者，如果服文蛤汤后表解了，但渴不差，还意欲饮水，恐怕这里头有停饮，要详细观察证候，如有小便不利可用五苓散，故用“与”不用“主”，就是让你参考的意思，“主”是肯定的，“与”是让你斟酌当时的证情，有用五苓散的机会可以用，如果病总是叫渴，又小便不利，肯定里边有停水。文蛤散这个药就是解渴，这在金匱要略消渴篇这么说：“渴欲饮水不止”文蛤咸寒止渴。此段“意欲饮水，反不渴者”，怎么用文蛤散呢？当然不是的。再看文蛤汤，也在金匱要略里头，在呕吐下利篇说“吐后，渴欲得水而贪饮者，文蛤汤主之”，得水而贪饮者，得到水没完没了的喝，怎么用文蛤汤呢？所以金匱这一段也错了，而且也没有吐后再用文蛤汤发汗的，“得水而贪饮”这是文蛤散证，在金匱要略里头文蛤汤应该是文蛤散。而本段是文蛤汤，这是穿插错误。因为文蛤汤是发汗药，是解热发汗，这里用文蛤不是解渴，就是意欲饮水而反不渴，不是渴饮无度，所以应为文蛤汤，总而言之，还是表未解，所以此段错的多，那医宗金鉴改的乱七八糟。底下这个不应该与此搁一段，搁一段就更坏了。

寒湿结胸，寒痰凝结，没有热，没有热证，纯粹寒湿，与三物白散，小陷胸汤错了，小陷胸汤治热不治寒，黄连、瓜蒌都为苦寒药，半夏去水而已。不治寒。这个白散正治寒湿，不治热。这里“小陷胸汤”几个字应去掉。文蛤这个药，医宗金鉴说是五倍子，五倍子古人叫文蛤，说的也有理，医宗金鉴里说试验过，文蛤治不了消渴，用五倍子反有作用。有些人认为文蛤，牡蛎这个药可治渴，文蛤这个药呢可能治渴，是海物的东西都治渴，尤其蛤露之类的，不过医宗金鉴说试验过，这个作个参考，我试验过五倍子，治消渴没多大作用，还不如

牡蛎、花粉，花粉牡蛎散都治渴的，在金匱要略百合病里有。叫瓜蒌牡蛎散，专用文蛤并不理想，五倍子我试过效果不好，作个参考。真正的贝壳类的文蛤没用过，五倍子用过，不象医宗金鉴那么说的好用。我想牡蛎可以治渴，文蛤也可以治渴。

五苓散头前讲了，不细说。看看白散，以桔梗、贝母二药排痰，寒痰凝聚，故用此二味排痰药，巴豆是热性的，又涌吐，又催下，这个药非常的猛峻，但是温热，寒湿古人都用巴豆，不用大黄，方后此三味药做成粉剂，以白饮和服，强人半钱匕，古人一钱是现在三分很轻，虚弱的人还要减，病在膈上必吐，在膈下必利，不利进热粥一杯，如不利，喝热粥马上就泻，利过不止，则服冷粥。巴豆我早些时候常用，巴豆用都要做成巴豆霜，先炒压成面子，用吸水纸把炒出的巴豆油吸尽，油非常厉害，故巴豆霜不那么猛暴。现在一般都没用，以前小孩子病，叫药铺做不放心，自己做干净，反复用吸水纸吸油，直到没油了，利过不止，喝凉粥一杯，就行，马上就止。上面“身热，皮粟不解，欲引衣自覆者，若水渍之，洗之，益令热却不得出”，这是胡说八道了，这节更糟，还身热，皮粟不解欲引衣自覆，引衣自覆是恶寒了，还用水灌，水洗的，没这个事，可见这一段非常乱，益令热都不得出，这解释热却不得出，其热被却不得去，解释这句话，但是与上边都连上了。当汗而不汗则烦，这名解释得好，当然要解表，要不用文蛤散呢？“假令汗出已，腹中痛，与芍药三两，如上法”这又乱说，这与方剂一点不合，这个白散并不能出汗，可见这节错了，白散是一温下寒饮的方剂。在肺痈、肺痿那一章就有的，假设寒痰凝聚而结胸的，即寒湿结胸，有用三物白散的机会，小陷胸汤不行。但是也有这种病，所以在这他还特别提一句，它是另一节，与上面那节是不一致的，不是由于冷水渍之，若灌之，而使人能寒湿结胸，这是错的，一般书在此解释的都不够好。

李冠杰：原文是：“病在阳、应以汗解之、反以冷水渍之、若灌

之、其热被劫不得去、弥更益烦、肉上粟起、意欲饮水、反少渴者、服文蛤散、若不差者、与五苓散、寒实结胸、无热证者、与三物小陷胸汤”。下边一个算是附注：“白散亦可服”。

在《康平本》里，这一条后边还附了一段文字是“身热、皮粟不解、欲引衣自覆者、若以水渍之洗之、益令热劫不得出、当汗而不汗、则烦、假令汗出已、腹中痛、与芍药三两如上法”。跟这条的内容基本上有点重复了，也把它算在这一条里边，它在《宋本》里是另外一种情况，我们在学习过程中会跟大家说。

这条在《康平本》中分成了两部分，一部分是顶格条文和方剂，另一部分是降一字格排版的条文，就是刚才我们读的“身热，皮粟不解”这一部分。条文中“反少渴者”，在《宋本》里是“反不渴者”，差别挺大，这是一个挺重要的问题。另外就是条文后边附的方剂，在《康平本》里就是“白散”这两个字，在《宋本》里是“白散方”，多了一个方字，这个没有太大的区别。

我们把条文分成两部分来学习，它本身就是两部分。

先学习第一部分，就是顶格条文这一部分：

“病在阳，应以汗解之”。从字面上看论述的就是太阳病，但是像“病在阳”这样的论述方式，在书里就一处是这种说法。虽然它没说太阳病，但是后边“应以汗解之”，这个治疗原则的解释就明显指前边，印证了前边说的是太阳病。但是我们整体解读条文，这个地方应该是一个太阳阳明合病，因为它后边有“弥更益烦”，也就是说里边本身还有烦的因素存在。这个“病在阳”，是不是里边有意识地包含了有阳明病那个意思呢？咱们现在就这么理解吧，因为这个条文中间问题很多，现在这么理解就比较客观一些。

“反以冷水渍之、若灌之”，这个“渍”和“灌”是古人用来降低体温的两种土办法。现代医学有时候也会用这种方法，比如人发了高烧以后用酒精棉球擦身上、擦腋下来降温，实际上道理是一样的。

但是“灑”和“灌”多少有一点区别，“灑”就是指的用冷水喷，一般是把水含到嘴里边，像喷雾一样喷到人的脸上或身上；“灌”基本上就是洗，相当于现在的淋浴一样，用冷水浇身上。目的都是降温，对人体的影响也差不多。

“其热被劫不得去”，实际上是对这种治疗方法的一种否定，这种方法是不科学的。这儿的热，当然主要是指太阳表证的体温高，“发热恶寒”嘛，这是主要的；其中也应该包括有某种里热的意思。因为后边有“弥更益烦”，弥、更、益这三个字意思是相近的，都是更加的意思，在这个地方加到一块儿就是“更加”的意思，就是说前边的应该发汗的时候，本身已经有烦的症状存在，所以说应该是有里热的情况。

“肉上粟起”就是平时说的起鸡皮疙瘩。人体的体表组织本来温度有点高，受凉水的刺激之后，发生的自然反应，汗腺收缩，出现鸡皮疙瘩。如果我们进一步的从“文蛤汤”（这儿说的“文蛤汤”后边会一点点把它弄清楚了）的临床应用资料看，这个方剂还有治疗像皮疹或者荨麻疹之类的作用。从这可知，这个“肉上粟起”比一般说的稍微着凉起一身鸡皮疙瘩，比那个面还要宽一些，恐怕也包括某种程度的皮疹这类的。

接下来“意欲饮水、反少渴者”。看看上边整个过程形成了一个什么样的局面？一方面他本来就有热，误治以后“热不得去”，所以引发“意欲饮水”，有点渴；另一方面，由于用冷水误治，皮肤汗孔被刺激都关闭了，一点体液也出不来了。本来想通过皮肤蒸发出去的这一部分水分滞留在体内，所以还存在停饮的问题。表现在口渴方面，反而口渴不是很重。“反少渴者”在《宋本》改成了“反不渴”，这一改应该是个错误。从治疗方剂上看，无论是文蛤散还是文蛤汤，因为都有文蛤，文蛤是治口渴的，它应该有口渴的症状。如果把它改成不渴，没有道理啊，人本来是个小渴，渴的不很严重，说它不渴那用

解渴的药干嘛呢？特别是这段条文的后边还有“若不差与五苓散”，“与五苓散”我们后边还会说，它应该有口渴一证。“不差”指的是什么？那不是口渴一证嘛！后边我们还会做讨论，要如果没有口渴证，再看看整个的这些症状，就失去了应用五苓散的基础了。

再往下就是“服文蛤散”，胡老认为应该是“服文蛤汤”，而且胡老是有根有据，历史上的伤寒注家持这个观点的也有，不是光胡老一个人，因为这个地方错误太明显了。这地方不是一个小问题了，因为等于说这个方剂错了呀，我们必须把它错的原因弄清了。首先看看“文蛤散”这个方子，它就是文蛤一味药，跟一般的散剂没有明显的不同。“文蛤”是海中有纹理的一种贝类动物的外壳，入药有治疗口渴的作用，这是主要的治疗功能。再看看这个条文，“文蛤”主要用来治渴的，如果用来解表，它没有这个功能。这个条文里论述的却是另一种情况，不是“文蛤散”能治得了的，它论述的是本来外有表证里有热证，又用凉水或喷或洗，把病人折腾了一通，病没有愈，反倒是加重了，“弥更益烦”嘛！像这样的病，用一味“文蛤”根本就治不了的。从文字方面，在经方里论述以某个方子治某种病，一般都是用“主之”，或者说“与”、“可与”，或者说“宜”啊。但是这个地方却用了一个“服”，在经方里用的非常少，他原文这个地方是不是“服文蛤散”四个字都是一个问题。

胡老说了这个地方“文蛤散”应该是“文蛤汤”，咱们看一下，“文蛤汤”是《金匱要略》“呕吐下利病脉证治第十七”里的一个方剂，那个条文里治的是“吐后欲饮”这种病，原文是“吐后，渴欲得水而贪饮者，文蛤汤主之”，后边“兼主微风、脉紧、头痛”。

“文蛤汤”是：文蛤五两，麻黄、甘草、生姜各三两，石膏五两，杏仁五十枚，大枣十二枚，方后注不说了啊。大家看一看这个方剂，对《金匱要略》里条文后边的“兼主微风、脉紧、头痛”几个字，就是后人所加的。因为他看到这个方剂应该能治疗表证，后来加上了。

像这样的说法在经方原文里一个没有，所以说这是后人加的，实际上是加的一个注解内容。真正条文里所论述的症状，吐了以后口渴，除了与“文蛤”这味药有关联之外，其它的都没有关联。它没有表证，一点儿都没有提到表证的事儿，只是说吐完以后，就是口渴，喝点“文蛤散”就可以治疗口渴。“文蛤汤”在《金匱要略》里也不对，它不应该在那个地方，《伤寒论》第141条里的“文蛤散”在这儿也不对。把这两个方剂如果互换一下，所有的东西都对了。把那个《金匱要略》里“兼主微风”那些注解文字删掉，把“文蛤散”放在那个地方，恰好它治那个证；把“文蛤汤”拿到这儿来，它也恰好治这种病，咱后边还会一点一点地分析。所以胡老对这个也是反复研究，最后得出一个结论：“《伤寒论》中的‘文蛤散’与《金匱要略》里的‘文蛤汤’，这两个方剂发生了相互错位”。

怎么会出现这种错误呢？根据史料记载《伤寒论》和《金匱要略》原本就是一部书。最早期的样式全书一共分三大部分：第一部分就近似于今天看到的《伤寒论》的内容；第二部分近似于今天看到的《金匱要略》的内容；第三部分是集中了前两部分里所有的方剂，也就是前两部分正文里是看不到具体方剂的，只是记上一个方名和一个号，然后到后边去查。就跟我们现在看的一些书，比如对某一句话有一个注解，就在这句话上边画一个小圆圈，圆圈里写一个数字，然后把注解放在这一页的最后，或者这一章节的最后，甚至是在这本书的最后，你要到那儿去找它注解的意思。在后来整理过程当中，为了阅读和使用方便，才把它改成了条文和方剂同条的情况。后来还有发展，《康平本》里所有的方剂都是出现一次，到《宋本》，有的方剂就重复出现好几次，就是为了用着方便嘛！那么这种情况如果把方名抄错了，往后附方的时候，势必就会发生错误，有可能是这种情况造成的，现在只能这么估计。

“文蛤汤”和“文蛤散”就一字之差，再加上这个条文多处都有

一些比较混乱的地方，所以说出现这种差错呢也在情理之中，也不是说多么离奇的事。这个地方就等于说是纠正了一个错误吧。这两个方剂在实际临床中应用的机率不是很高，再加上书上又发生了这样的错误，以至于在临床中统计数据都很难找到。也就是说在临床中用的都非常少，真是对这个方剂的应用影响挺大。

如果把这两个方剂调换一下，再去体悟体悟好多东西，还挺有意思。“文蛤汤”治什么啊？它近似于一个大青龙汤，药物组成非常接近，后面方解里再去讨论。这个地方论述的这种情况，就特别适合用这个方剂来治：有热，到不了大青龙汤那种程度；有表证，即使说表实严重也是由于原本有一点表证，用凉水刺激后才形成的。所以在青龙汤基础上把桂枝去掉，把麻黄减量、把石膏减量。

再往下看条文：“若不差者、与五苓散”。这个文字就有点太简了，“若不差”这个“差”字应该是“瘥”，古代就用这个差，是同一个字。想理解“若不差”的意思，必须得去参照五苓散这个方子，实际上它也就是这个意思：我后边有方剂，前边有它整个发病和误治的过程，其它的东西在这儿我就省略了。它的意思并不是说服了文蛤汤以后，病没有变化，然后就可以用五苓散来治，不是这个意思。这个“不差”是说服了文蛤汤以后，表证也轻一些，里热也基本消除了，但是还有口渴“不差”。它前边有用凉水喷，水不能从体表排出，就有停饮的情况，如果人内部的体液代谢有问题，小便再不利，那就成“五苓散证”了，就得用五苓散治就行了。再遗留一点表证也没有关系，五苓散可以解决了。实际上这个五苓散是一个后续的问题，不是说服文蛤汤方证不对，连前面那些“弥更益烦”什么的证都要用五苓散来治，不是那个意思。

下边“寒实结胸，无热证者”。这儿的“结胸”和前边条文里所说的“结胸”有本质的区别。虽然可能症状反应上有一些接近的地方，但病理上存在质的不同。白散证与大小陷胸汤证相比较，在病理上虚

实属性少，它都是水实证、水内结，但是在寒热属性上完全不同，这儿“寒实结胸”在病理上是属寒、属实，这儿就把病理交代得非常清楚，在症状反应上，它又跟结胸证有一些相似之处，常常表现为肺部的一些症状，甚至有时候也会表现为胸胁部、心下（胃部）的一些症状，所以也把它称作“结胸”。后面又特别强调了“无热证者”，这不仅仅是指的体温高低问题了，还有就是说舌、脉各方面都不应该有热象，有热象就不叫“寒实结胸”了。

再接下来“与三物小陷胸汤”，后边还加了一个注：“白散亦可服”。这儿很明显就是一个错误。为什么啊？因为条文后边附上的方剂是“白散”，方名就叫“白散”，那么这个地方的“与三物小陷胸汤”明显是一个错误。后边的“白散亦可服”，在《康平本》里清清楚楚地看出是一个注解内容，是后来加的注解。所以它无法更正前边这个错误，还给我们保留了条文原来的样子，加了一个注解。但是到了《宋本》的时候，因为注解内容窜入了正文，就发现把它接上以后不通，把“白散亦可服”五个字另起一行附在条文后面，弄得这个条文就更乱了。

如果去参照一下其他的版本，这个地方的混乱现象还要复杂一些，比这个还要复杂。像《玉函经》三卷和《千金翼方》卷九，那儿写的是“与三物白散”。虽然看文字意思都通顺了，但是呢它跟《康平本》中这个方剂的名称还是多了“三物”两个字，严格说还不是完全对，它没有道理。《金匱》里有方名和条文里的方名不太对的，那个有的是为了省略，像这个多“三物”两个字，原方里面没有，实际上还是从“三物小陷胸汤”改过来的，发现有这么一个问题，然后就改了一下。

纵观一下这个条文，全面地看一看《康平本》的内容，条文存在很多个混乱的地方，我找了这么几点：

一个是方剂的错误。刚才咱们说了，它跟《金匱要略》里的“文

蛤汤”发生了互换的错误。

第二个就是“反少渴”后来改为“反不渴”，这也是一个明显的错误。

第三个是这个五苓散有名无方。在《康平本》里所有的方剂都只出现一次，这个不算什么奇怪。可是其他的地方没有方的时候，没有这个方名，在《康平本》里孤零零的一个方名，后边既没有方子也没有方后注。那么要是没有的话，方名也不应该有，为什么又出来一个方名？不得而知。这儿乱的真就是毫无道理。

第四个“服文蛤散”，其他地方很少有“服”什么方剂这种论述方式。

第五个，这个“白散”。《康平本》里“白散”就两个字没有方，其它方剂的方名大部份后面都有，比如“白散方”应该有个方，但是这里没有。这也没有道理，其它的方都有，为什么非要把这个去掉呢？也不知道为什么。

第六个就是“白散”这个名字各式各样的。刚才我们说了，不同的版本里也是特别的混乱。

另外，比如像“病在阳”这样的论述，原文是不是这样的也不好说。

还有一个，就是“白散”这个方剂的方后注。“白散”方的方剂和方后注在《康平本》里为降两字格排版的内容。《康平本》里降两字格排版的方剂，只有几个，这就是其一。麻子仁丸也是一个降两字格的排版，其它的方剂和方后注都是降一字格排版的。这个方剂这么乱，方剂又发生易位，这个“白散”方，跟《金匱要略》里有一个方是一样的，还不叫这个名字。原本到底是怎样的？现在真是很难知道了。

我们通过学习《康平本》能看到的这些问题，在这个书里也不仅仅是这一条有，其它的地方也有此类的问题，只是没有这么多的问题

都出现在一个条文里。像这个正反映了这一本书的严格，就是这本书从历史的传承过程中的一个真实反映。大家都知道张仲景写完了以后就失散了，中间肯定会有很多的周折，王叔和在搜集整理的过程中肯定也有很多周折，具体细节不知道了，要知道的话这这也是一个很生动的文学素材，里面会有很多故事的。现在实事求是的去看待这些东西，我们才能学到真正的东西，有一些明明不是张仲景写的东西，不能一股脑的都扣到张仲景身上，说仲景怎么怎么着了，那样等于是糊里糊涂的学，最后学到手里的东西打了折扣，等于对自己不负责任，如果留下点痕迹的话，对后人也是不负责任。

下面对这条做个小结：太阳阳明合病，本当发汗解表，但是医者反用冷水喷淋或者浇身，致使里热不得去，而烦的症状更加严重；患者皮上粟起，意欲饮水、反少渴的，可用“文蛤汤”治疗，如果服药后仍不愈的，可给予五苓散；若属寒与水结于胸胁，而且无热证的可以予以“白散”治疗。

这个我觉得是价值最高的一个小结了，把条文里好多我们能理顺的地方，基本上都理顺了。

下面我们看一看方子，先看一看“文蛤散”与“文蛤汤”。刚才说了，由于条文上面这两个方剂发生错位，再加上特别是近代临床中，真正用喷凉水降温的方式越来越少，临床应用这两个方剂的机率都非常低，临床资料也比较少。

我现在手头有两本非常专业的书籍，两本书的作者却犯了非常机械的错误。本条文明明存在着这么明显的错误，作者却仍然用第 141 条的这些症状去界定“文蛤散”，说“文蛤散”就治这病，有解表的功能。这有点太机械了，明显的是“死于句下”。而且书上用条文论述的症状来界定“文蛤散”的主治，也挑了一些医案，可是医案都是治疗消渴的。这本身就是自己制造矛盾，我觉得还不如那个机械的，这个是自己搬起石头砸自己的脚，有点太牵强了。不知道这些学者当

时想什么？反正我觉得研究经典不应该有这种态度，最起码自相矛盾不行。

“文蛤汤”的药物刚才说了，不再重复了，这个方剂的组成和大青龙汤比较接近，可以视为大青龙汤去了桂枝加上文蛤，然后麻黄和石膏减量。“文蛤”在《中医辞海》里是：味咸、性平、无毒，入手太阴肺经，足太阳膀胱经，清热、利湿、化痰、软坚、治口渴烦热、咳逆、胸痹、瘰癧、痰核、崩漏、痔瘕，这是“文蛤”的功能。因为这个药弄清了，文蛤散和文蛤汤的功能也就比较清楚了。咱们看到“文蛤散”根本就没有解表的功能，所以这两个方剂应该调过来。如果再看看条文里这个方证就容易理解了，之所以说是在大青龙汤的基础上做的加减，就是说原本有热，但热的程度到不了大青龙汤证的那种程度，只是有点儿烦，后边更烦是因为用凉水刺激了；原本有表证，表证也到不了大青龙汤证的那种程度。要是到了前边肯定会有，就不会用“病在阳”这么简单的论述了。误用冷水刺激以后，受刺激最大的就是体表了，但是它跟真正的大青龙汤证的表实证还不完全一样，这儿因为是外界刺激，只是体表的“汗不得出”这么一种情况，所以说把桂枝给去了，麻黄也减了减量，因为有口渴，所以又加上了文蛤，方和证应该是特别对应。

这个方剂有一点资料，内容也不多，反正是这两个方剂在临床中应用的机率比较低，从它治疗的这种情况也能看出来。

这两个病例症状基本相同：全身起风疹，突出于皮肤，大小不一，瞬时可连成片，并见脸肿、手足肿（这有水饮啦），瘙痒难忍，烦躁不安，伴有失眠、胸闷、纳差等。其中一例记载有上述症状的同时，夜间遇风或入冷水时会加重，就有一个记载的舌质是偏红色，两例都是白苔，明显看出是里热不重；脉象一个是浮，一个是浮滑。这两个医案对应的现代病，最后的总结就是：表实内热所致的荨麻疹。我在其它书上也找到一个资料，说这个方剂可以治疗胃肠型的感冒及慢性

胃肠炎、过敏性皮肤疾病，大概有这么一个轮廓。

下面再看看“白散”这个方子。这个方剂由三味药组成：桔梗三分，巴豆一分，贝母三分。桔梗是平性的药，寒热倾向不明显，它有开宣肺气、祛痰排脓的作用；贝母是一味偏凉性的药，微寒，它有润肺、散结、止咳、化痰的作用；巴豆是一味热性药，有毒，它有泻寒积、通关窍、逐痰、行水、杀虫的作用。因为条文中论述的这个病的病理，它是“寒实结胸、无大热”，但是没有具体的症状反应，要想理解这个方剂，我们有其它的资料可参考。在《金匱要略》“肺痿肺痛咳嗽上气病脉证治第七”附方里有一个“桔梗白散”，这个方子和这儿的“白散”的药物组成和剂量是完全一样的，可以互参。在《金匱要略》里原文是“《外台》桔梗白散：治咳而胸满，振寒脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥样，为肺痛”，这是“桔梗白散”的适应证。

这个地方如果思路再宽一点，它跟苇茎汤可做一个比较：这一个治的是肺痛，那个治的是也肺痛，临床表现也非常相似，但是一寒一热、一虚一实。

在这个方剂的方后注里，有值得我们注意一点的，就是说服了以后，如果病在膈上的会吐，在膈下的会下利。如果不下利的进热粥一杯，利过不止进冷粥一杯，这个在临床中都有验证，确实有效。

从这个地方我们看出一个问题来。古人说的这个寒热，实际上最终还是一个温度的问题。从这一点上，用了热药就下利，然后喝点冷粥就马上利止了，这不跟温度有关么？当然温度的背后是一个病理的问题，但是它说的寒热最终还是体现在温度上。

白散方证的临床统计：

症状：总共有症状记录的是十四个案例。厥逆、大便不通、心下硬满、咳痰、呕逆。

舌质：红、淡红、暗红。

舌苔：白、腻、黄、厚、薄、干。

脉象：沉、滑、细、弦、数、微、浮。

现代应用中有治愈记录的疾病：慢性气管炎、急性肠胃炎并发肺炎、渗出性胸膜炎、渗出性腹膜炎、肝硬化腹水、肾性水肿、小儿重症支气管肺炎、白喉重症、流行性出血热、痢病、狂乱、小儿消化不良性腹泻、急性喉炎合并喉不全梗阻。

这个第二部分是降两字格排版的内容，刚才我们已经读过了，就是从“身热、皮粟不解”之后一直到“与芍药三两如上法”为止。这段文字内容比较特殊，有的版本如《玉函经》里甚至都没有它。这个“身热，皮粟不解，欲引衣自覆者，若以水渍之洗之”，好像是作者对正文的进一步补充，论述的这些东西跟顶格条文里论述的比较相似。但是这里有一个问题：既然是误治都已经到了那种“欲引衣自覆”，也就是说非常怕冷的程度，医生又用冷水“渍之洗之”，就是再用冷水去降温，应该说没有道理。胡老在这个地方就觉得这里说得根本不可能，那个医生除非是弱智，但它这儿就是这么写的。

然后还造成后面“益令热劫不得出，当汗而不汗，则烦”。这里论述的与原文相比，除了它这儿是再次误治之外没有质的区别。这两部分等于整个地论述的这个，现在临床中发生的机率也比较低了，我们做个参考吧。

下面“假令汗出已，腹中痛，与芍药三两如上法”。这个与上面不太衔接，这儿到底是一个自愈啊？还是一种什么情况？让人感觉很含糊。特别后面“与芍药三两如上法”，这个条文应该是在“白散”的后面，三两芍药是加在“白散”里面？还是把芍药做成粉服散呢？就不得而知了，让人感觉交待得很不清楚。这呢就是说这一段，对我们现实意义也不很大，仅仅做个参考吧。

到第 178 条整个太阳病上、中、下就学习完了，如果再去仔细地看看《康平本》，就会发现后边相当大的篇幅里顶格条文逐渐减少。

《康平本》这种排版的方式能看出不同作者的内容，然后再去看一下为什么主要的内容都集中在太阳篇里？其它篇里的顶格条文为什么那么少？甚至到一种类型的疾病只有几条顶格条文。学完了太阳篇以后再学习的时候，你去整体地感悟一下，会有另外一种想法，我现在等于说让大家预习一下！

太阳①与少阳并病、颈项强痛②、或眩冒、时如结胸、心下痞硬者当刺太椎①第一间、肺俞、肝俞、慎不可发汗、发汗则谵语、脉弦、五日谵语不止、当刺期门、（142）

注：

1. 《康平本》此条文有如下眉注：“太阳及太椎之太字·一本作大”。另“太椎”《宋本》作“大椎”。
2. “颈项强痛”《宋本》作“头项强痛”。

胡希恕：太少并病，古人解释是太阳病传入少阳而发生少阳病，太阳病还没解，叫并病，头项强痛是太阳证，或眩冒时如结胸心下痞硬，这是少阳证，可是少阳证不明显，搁个“或”，有的时候眩冒，“少阳之为病，口苦咽干目眩”，有时眩冒，有时结胸，心下满，如结胸，心下痞硬，小柴胡汤也心下痞硬，有人参，太阳少阳并病，太阳证还存在，少阳证不太明显，时有时无，这个也正说明柴胡证若有若无的时候，可以用针刺，这段的意思在此。当刺大椎第一间，这个大椎就是第一胸脊那个线中就是大椎第一间（在第七颈椎与第一胸椎刺突之间）。那么这个穴的作用是泻胸中热气，这个表证也属于上焦的，少阳病也是。肺俞在第三胸椎下面两旁各取一寸五，肺俞是两个穴，肝俞在第九胸椎下面也是两旁各取一寸五，这两个穴……………（30：56—31：13 没录上）。慎不可发汗，少阳病是不可发汗的，发汗则谵语，脉真正弦了，真正变成少阳病了。不但少阳病，而且他

有胃不和，有谵语。那么谵语，五日的时候谵语还不止，那么这个时候他就变成少阳阳明并病了，那么也可以是实证。这个期门，就是乳头直下六、七肋骨之间。期门穴它祛胸中的邪热，常常少阳病柴胡证不明显也有刺期门的，那么这个虽然这么说，用柴胡证行不行呢？我认为行的，这个可以吃小柴胡汤。太阳和少阳并病，如果少阳证不明显，但时有时无的时候也可以用针刺的治疗方法。这一段的主要意思是说明这些问题。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边，是降两字格排版的条文。

在整个《康平本》里边，说太阳病这个地方，几乎是唯一一次真正用了个“太”字，但是这个条文里边还有一个，本来是“大椎”，但是他反倒是写成“太椎”了。竖排版的《康平本》这里有眉注，正文的上边它有有一些注解的内容，写得就比较清楚，它说译本作“大”，就是指的“太椎”和“太阳”，这两个字都不分。有的版本是“太”字，在这儿译本作“大”，换句话说就是在日本国内有不同的传抄的版本，都是《康平本》，你抄的和他抄的在这个地方有区别。实际上这个地方两个字正好全都错了，这个“太椎”在《宋本》里边就是一个“大椎”，这个是对的。

“颈项强痛”，在《宋本》里边是“头项强痛”，这个有可能是王叔和在第二次整理的时候，他经过考虑又做了一个修改。

下边我们解读一下：

“太阳与少阳并病，颈项强痛，或眩冒，时如结胸，心下痞硬者”，这个“颈项强痛”本身就是太阳与少阳同病的一种症状反应。但是到了《宋本》里边，他可能是经过考虑，或者说是抄错了，又改成了“头项强痛”。“头项强痛”就明显的、单纯的指的是太阳病的症状反应。后边“眩冒，时如结胸，心下痞硬”这一类的，都类同于少阳病的症状反应。

“并病”在经方理论里边就是指：一种疾病还没有痊愈，而又发

生了另外一种类型的疾病。

“当刺（这个地方咱就直接读大椎吧）大椎第一间、肺俞、肝俞”，实际上就是大椎穴和足太阳膀胱经里边、足太阳膀胱经络上边的肺俞和肝俞穴。这是作者对上边论述的这些情况，给出的用针法治疗的这么一个方案，这个治疗方案可以参考。

但是《伤寒论》是一本经方书，我们会首先考虑到一个疾病是不是可以用方剂来治疗，如果仅仅从条文里边所列举的这些症状看，还看不出一定要用针法治疗的这种必要。比如太阳少阳合病的话，柴胡桂枝汤就是一个比较好的方剂。具体症状里边有出入的话还可以用小柴胡汤合上葛根汤，这也是常用的合方的方式，也未尝不可。这个地方要用针法治疗，咱们就做个参考吧。

“慎不可发汗，发汗则谵语”，这是经方理论的一个常识性的问题，也就是说太阳少阳合病的话，你就不可单独用发汗的方法治疗。这儿也例举了一个一旦你要误治了以后，有可能出现的一种变证、不良后果。

“脉弦，五日谵语不止，当刺期门”，这儿论述的就是误发汗以后，半表半里证不得解，实际上像这种情况下误发汗的话，表证也不一定能解了。但是这时候又发生了里热证的这么一种不良的后果，同时还给了一种治疗方法，就是“刺期门”。凡是对里热这一类的，跟半表半里又同时出现，降两字格这个作者，很偏向于用这种“刺期门”的方法治疗，这个咱们也可以把它看做临床经验。

下边做一个小结：太阳与少阳并病，症状表现为颈项强痛，或眩冒，时如结胸，心下痞硬的，当刺大椎第一间、肺俞、肝俞，切不可用发汗的方法治疗。误发汗则可能发生谵语，此时如果脉弦，过五日的时间，谵语仍不止的话，当刺期门。

妇人中风、发热恶寒、经水适来、得之七八日、热除而脉迟、身凉、胸胁下满、如结胸状、谵语者、此为热入血室也、当刺期门、随其实而取之、（143）

胡希恕：“妇人中风”就是女同志中风，多的是太阳中风证，那么开始发热恶寒，那么在八九天的时候，经水适来，就是来月经了。那么来之后，热除而脉迟身凉，这个热入血室常有这种情况，它正在感冒这个阶段，来月经了，乘这个行血子宫虚，那么外表的邪热，乘子宫之虚而入血室，妇人血室就是指这个子宫了，所以这个表证没有了，热除而脉迟身凉，可是都陷入血室了。所有人身上是这样的，哪个地方虚，这个客邪之气就往哪里去。所以《内经》里有句话：“邪之所凑，其气必虚。”那么我们泻下药，胃他不虚，你吃泻药他就虚，这个病它就是往里边去。所以邪热陷于里，女人来月经了，在流血的时候，子宫虚了，邪热就乘虚而入血室了。胸胁下满，如结胸状，这个热入血室常常现柴胡证，胸胁下满，如结胸状，也就是柴胡证候，谵语呢？阳明证也有，这个热入血室与前面的桃核承气汤的证是一个样，这个谵语就是说胡话，没到如狂这个程度上，但是也影响脑系，这也不绝对是阳明，那么这是热入血室造成的。当刺期门，随其实而泻之。虽然这个热淤于下，热入血室，但是这个证候的反应啊，在上面，胸胁下满，如结胸状。实反映在上头，所以随其实而泻之者，实在这个胸胁下满，如结胸状。这个期门就是结这个地方，指实热，所以这个期门在针灸上它是祛胸中邪热。随其实而取之，是随证之实而取穴而治疗。

李冠杰：这一条也是一个降两字格的条文。

下边解读一下：

这个条文论述的是什么？就是女性病人患了太阳中风之后，数日不愈，又恰恰赶上了月经来潮，这个时候出现什么状态呢？表证消失了，却发生了少阳病和阳明病合病的情况和相应的治疗方法。

“妇人中风、发热恶寒”，这就是典型的太阳表证了。“经水适来”，太阳病还没有愈的时候，月经就来了。“得之七八日”，这儿的“得之七八日”指的是什么？指的应该是月经来潮之前，太阳病已经有七八天的时间了。要不然的话这个地方就讲不通了，你不能说是月经来了七八天，这个事就不太合理。这儿说明什么呀？说明这个病程比较长，人体的抵抗力不足，在这个特殊时期疾病常常会出现进一步的发展。

那么出现什么情况呢？“热除而脉迟、身凉”，也就是说月经来潮之后，像表证的发热恶寒这些症状都消失了，“热除”嘛，脉也变得迟了，也没有发热的那种情况了。但是，还有新的症状就是“胸胁下满、如结胸状”，实际上就是类似于少阳病的症状反应。“谵语者”，应该是典型的阳明里热的症状。

你看这儿说的，就是由于患太阳表证多日不解，又加上月经适来，这人体的抵抗力就明显的降低了。这论述的就是说人体当行经的时候，抵抗力降低，没有能力再在表与疾病做斗争了，然后表证的症状就消失了，进而就发展为少阳和阳明合病。

“此为热入血室也，当刺期门，随其实而取之”。因为上边的情况的发生与行经有着比较密切的关联，所以古人就称作是“热入血室”。这个“血室”指的是女性的生殖系统。并且认为这是一种实证，所以说“随其实而取之”，具体的治疗方法也是刺期门。

我们通过读这个条文能有这样的感觉，这个条文应该是这个作者来自于他自己的临床经验，或者说当时医学界的临床经验的一个总结。从经方病理角度来分析的话，这个条文论述的实际上就是少阳阳明合病并且又有瘀血证的因素存在，比较近似于大柴胡汤合桃核承气汤证或者小柴胡汤合桃核承气汤证。

但是仔细看的话，它跟真正那个方证有区别，区别在哪？他这说的很清楚“脉迟身凉”，“脉迟身凉”是说像这类的情况是“热入血

室”了，是热证的表现不错，像谶语，这是典型的热证的表现。但是身也不发热，然后脉还表现的比较迟，恐怕这个“迟”也有另外的因素，就是跟以前患太阳病发热的时候比相对迟了，恐怕也有这方面的因素存在。如果说病人真正到这种情况下，脉会不会明显的迟？因为他不是阴证，他到不了阴证的那种程度，会不会明显的变得很迟也难说。另外还有一个因素，这个时候，这个病人正值行经期间，所以说再加上“脉迟身凉”，像这些因素综合到一块儿，再用苦寒的药，用一些攻法或许不太合适。这儿呢就用了针法，也就是说这条里面明显能够看出来，所以最后给了一个用针法的治疗方案，那么这里有不宣用方剂的这些因素存在。

下边做个小结：

女性患者患太阳中风证，发热恶寒已七八天的时间，恰值月经来潮，其症状变化为脉迟身凉，胸胁下满，如结胸状，谶语的，这是热入血室，需祛实热，当刺期门。

妇人中风七八日、续得寒热、发作有时、经水适断者、
此为热入血室·其血必结、故使如疟状、发作有时、小柴胡汤主之、①（144）

注：《宋本》此处有小柴胡汤方及方后注，此从略。

胡希恕：这里提出柴胡来了，妇人中风在七八天的时候，发热恶寒没有了，但续得寒热，发作有时，变成寒热往来了，就象疟疾似的。以前来的月经在这时没有了，即七八天前已来了，月经到此时停了，经水适断，发生上面那种情况，这也是热入血室。其血必结，就是月经中断，血与热必结了，故发作上面的往来寒热，发作有时，这可以用小柴胡汤。书上是这么说的，实际是不是，还得看情形。头前这一段也可用小柴胡汤，胁满痛如结胸状都可以用。

在临床上我个人认为只是用小柴胡汤的机会不多，一般配桃核承气汤或桂枝茯苓丸，主要看可下不可下，可下，要是谵语，大便几天不通，你可用大柴胡汤，桂枝茯苓丸或桃仁承气汤，不可下，大便不干，而且反溏，用小柴胡汤合桂枝茯苓丸相当好，看这些证候，单用小柴胡汤不多。

李冠杰：这条文在《康平本》是顶格条文，《宋本》这条的后边附有小柴胡汤和方后注，《康平本》里没有。

我们解读一下：

“妇人中风七八日”就是患太阳病已经多日了，暗含疾病有进一步发展变化的条件。

“续得寒热、发作有时”就是说有规律性的发作“往来寒热”，本意就是这么一个意思，这是典型的少阳病的症状反应。

“经水适断”。恰恰在这个时候，月经如期而至，正常的来潮，但是比正常的经期明显的偏少，不应该断，是不到时就中断了。比如一天两天月经就没有了，比正常规律下要短。“适”就是恰好的意思。

“此为热入血室”，这是一个旁注的内容，是为正文做的病理解释。我仔细进行了核对，值得我们注意的是经方这两本书（《伤寒论》和《金匱要略》）出现“热入血室”的，一共有八条条文，《伤寒论》和《金匱要略》各四条。但是《金匱要略》里的四条跟《伤寒论》里的四条几乎是完全重复的，也就是说它是从《伤寒论》里抄过去的，实际上只有四条条文出现“热入血室”。这样我们抛开《金匱要略》，只谈《伤寒论》里的这四条，《伤寒论》里的四个条文，或者是降两字格排版的，或者是降一字格排版的，或者是为顶格排版条文加的旁注，顶格条文里没有这样的说法。尽管这里边没有多大原则的问题，但这是一个客观存在的问题。是不是《汤液经》成书的时候，医学界可能还没有类似的提法；或者说，顶格的条文一般尽可能地避免去讨

论某个具体的脏腑，某个具体的病变部位。这里边有更深层次的问题，所以胡老最终解读出来的结论就是：经方的理论和《内经》的理论是两个不同的体系。这是一个非常重要的问题，《内经》研究疾病、病理、人体的思路，是从人体的结构、功能等方面开始的，经方不是这个样子，大家可以慢慢去体悟。

“其血必结”是对女性病人在特殊时期出现的这种症状所做的病理解释，这才是真正的病理解释啊。就是由于人体发生了少阳病而影响到了经血的正常运行，并且给出了具体的治疗方法，就是“小柴胡汤主之”。

“故使如疟状、发作有时”。前边说的“续得寒热”实际上本身就是指的这个寒热，特别是少阳病的往来寒热，严重一点就如疟状，一阵冷一阵热。而且这两个“发作有时”文字完全重复，出现在同一条里让人感觉明显的重复。“故使如疟状，发作有时”以前是不是嵌注的文字，在抄的过程中可能跟正文混了？这也是有可能的，特别是顶格条文中这类的重复情况不多。但是也没有什么原则问题，只是说的更具体些、更形象些。

这个是一条比较典型的条文。它说了一个比较特殊的情况，就是说女性在例假期间患了疾病如何治疗。

有人用另外的方法来理解这条，倪海厦的观点说女人如果月经期得了感冒，只有小柴胡汤一个方剂可以治。这个地方的几条都是论述这类情况，明显能看出女性患者在行经的时候，她的抵抗力明显比正常情况下要低一些，如果患感冒，纯表证的机会就不多，常常会带有半表半里证的症状反应，所以就把它机械的给归纳成：凡是女人经期得感冒就用小柴胡汤。实际上这是机械的套用条文。

大家去看一看胡希恕怎么说的，他说这个时候如果真正有柴胡证，用小柴胡汤；如果有明显的其他证，比如有严重的表实证——葛根汤证，用葛根汤与小柴胡汤合方也没什么不可以。其实经方的理论

前前后后都是一致的，还是要辨证，不能机械的去套用。但是有个事实，就是女性患者在这个时期患小柴胡汤证的几率比较高，患这种病就要有这种病的证候。

给大家说一个医案：一个 30 多岁的女性患者，是一个医院的护士，因为身体长期不好，手脚冰凉不是一年两年了，让她吃的是四逆汤，吃了以后身体一天比一天好。恰恰在这个过程里来例假了，第二天她给我打电话说：我这例假来了，又恶心又想吐，身上一阵冷一阵热。我就给她小柴胡汤，给了两天的药，结果服了一天她又给我打电话说：我自从有例假就没有来过这么多，把单子都弄湿了，但是觉得浑身特别的轻松，饭也愿意吃了，感觉非常好。我说你要如果想吃就再吃两天，她后来又拿了两天的药，这个病也好了，她的行经期也过了。结果她发生了什么样的变化呢？她以前长期有四逆汤证，“但欲寐”啊，平时很少跟同事们在一块有说有笑的，有时间就跑到自己办公室的床上躺着。吃了小柴胡汤以后精神也好了，心情也好了，体力也好了，跟同事有说有笑。别人就说她以前是不是装的啊，现在跟换了一个人一样。后来，她们医院的不少人到我这里来看病。

下面做个小结：女性病人患太阳中风证，已有七八天的时间，进而又出现了寒热，而且发作有时，因正值月经期，其经血也随之中断，这是由于热入血室而造成经血截止，所以致使病人像得了疟疾的样子，发作有时，此为小柴胡汤主治之证。

这儿也有它强调的“发作有时”。咱们后面学柴胡桂枝汤的时候，就能比较突出地看出“发作有时”来。实际上这个地方强调的是“往来寒热”，不仅仅是平常柴胡证的“往来寒热”，还伴随着“发作有时”。“发作有时”咱们曾经说过，有多种表现形式：比如固定的时间、固定原因造成的等等，都会明显的发生这类的症状，咱们在柴胡桂枝汤证里再做进一步的讨论。

妇人伤寒发热、经水适来、昼日明了、暮则谵语、如见鬼状者、此为热入血室、无犯胃气及上二焦、必自愈、（145）

胡希恕：在外感初作，此时赶上月经来，这也是好事，头一条，热入血室，如果经脉不结，邪也随血去，也象衄血一样，但是如果不去，发生证候了，胸胁下满如结胸状，越结越实，这个有证候可治，第二段更不用说了，血与热结了，经水适断了，那么这节说不用治，没有别的毛病，继续行经，只是夜晚说点胡话，这不要紧，暮则谵语如见鬼状，但白天清楚，这个不要乱治。没有胸胁满等其他证候，经水正常，无犯胃气及上二焦，即是不要吃泻药及发汗等治疗。必自愈。如果不自愈，经血突然中断，或发生其他证候，还是要治。一般说在感冒或流感时赶上月经来，不一定发毛病，如热入血室，没其它毛病，热可随经行而解的，也有。这段说明这个问题。热入血室，有的很厉害，如桃核承气汤，其入如狂，发热挺高挺高，这个很多的。

李冠杰：这个条文在《康平本》里面是降一字格排版的条文。

咱们解读一下：

“妇人伤寒发热，经水适来”，就是女性患者患了太阳伤寒之后，发热呢，这是表实证的一个典型症状反应了。正逢上月经来潮，这一时期人体抵抗力比较低，疾病容易发生变化。

那么出现什么反应呢？“昼日明了，暮则谵语，如见鬼状者”。昼日指的是白天，暮指的就是晚上。白天和正常人一样，但是到了晚上就说胡话，甚至是跟见到了鬼一样，或是症状反应还比较强烈。

作者就解释了：这就是一种“热入血室”，而且和“胃气”及“上二焦”没有关系。这是作者病理方面的解释，这个地方比较重要。这里面有一个具体的问题，我们现在在临床当中遇到这一类情况的机会，相对来说比较少。因为咱们今天的人，体质跟两千多年前的古人是绝对没法比了，我们的体质因为有了优越的生活环境，无论是在体

质方面，还是对疾病的抗御能力方面，都有所降低。从整体上说，我们现在整体的寿命比古人要高多了，但是我们现在的整体的体质却绝对不如古人。这里面为什么会出现比较矛盾的这么一个局面呢？古人那个时候平均寿命比较短，这里面有许多因素存在：一个是生活水平，一个是战乱，再一个是医疗水平。不是说没有好医生啊，也有好医生，但是少啊，医疗条件差，有的是看病看不起，有的是身边没有好医生，耽误了，所以平均寿命比我们现在低得多。

但是我们现在用不着倒退到古时，去考查两千多年以前人的体质水平是啥样子？像我小时候，还有一些记忆比较深的，我身边有些大人得了病以后，经常会用一些土办法去治疗。像模仿刮痧，用东西刮一刮身上，刮一刮头啊；模仿拔罐，比如说头痛就用手捏一捏，用手把它揪得变了颜色；有的用一块砖放到锅灶里把它烧热了，然后用布包一包，烫一烫身上某些部位，经常用一些土办法治疗。但是那个时候的人得病，常常是高烧，或者得一些比如拉肚子什么的。那时候的症状比我们现在的症状，也就是倒退 40 年，就比我们现在的症状反应要强烈的多。这本身就有两方面的因素：人们平时看病的机会少，实际上他抗病的机会就多；抗御疾病的机会多，相对他的抵抗力就比较高。比较高的抵抗力也有抵抗不住的时候，致病因素非常强的时候，他也会得病的。双方是打仗的战士也就比较激烈，症状反应也就比较强烈。

再看现在“亚健康”的人，前两天报道了一个开网店的人，一个月可能能赚一百多万，开的网店特别辛苦，上半夜从来都没睡过觉，都到黎明的四五点钟才能睡一会儿。有一次，半夜开着车去上货，结果就死在车里面了。后来记者采访他的弟弟，他弟弟说我哥身体特别好啊，好几年都没得过感冒，实际上这并不是身体好的表现。

后面作者说了“必自愈”，这一点非常重要。他说这一类的情况，你别看她症状反应非常强烈，你不要治，她不是因为胃气不和造成的，

这也是来自临床的实践经验。大家想想，这个人白天跟好人一样，晚上突然神志不清，说胡话，甚至怪声尖叫，跟见了鬼一样，做一些非常反常的动作。这时候谁能不担心，谁能不带她去看医生？而且大部分医生看到这种情况，或多或少都会采取一些治疗措施。你要真的采取了治疗措施，比如用了桃核承气汤了，或者是用了调胃承气汤了，或者说你用了现代医学的镇静剂了。实践经验是个什么样？这就是跟例假关系比较密切，这个时候你要治的话，她本身的抵抗力就比较弱，要真用了这种攻伐的方法，对人体的影响很大，反倒是有可能产生别的疾病。当然你要是不管她，等她例假过去以后，这个病也就好了。这完全是来自于临床实践当中的经验。

作为我们现在，你要是能理解它的道理，对临床也有非常重要的指导作用。比如我们现在遇到这一类的情况，比如说你的一位邻居，你到那儿看看，问问她是不是来例假了，然后再问一问她平时是个什么情况，多长时间了，你做个判断，至少你可以说等一等，看看明天什么样儿？如果她明天白天又正常了，或者她不一定真的跟患了精神病一样那么严重，比如她特别烦躁，心神不安的，也属于这种情况。要是能够断定她没有其他的病，你就可以告诉她没有关系，你不要在意，平时多休息，等你例假过去就好了，自己就好了，这不就完了嘛。本来挺简单的事儿，你要是说治疗的话，症状挺明显的，有可能治出别的什么问题。像这个就是古人给我们留下来的财富，来自临床的。

下面做个小结：女性患者得伤寒病并且发热，却正值月经来潮，于是发生了白天如常人，但到了晚上则发生谵语，甚至如见鬼的症状，这是由于热入血室造成的，而不是由于中焦或上焦部位发生疾病的反应，这种情况可自行痊愈，不必妄加治疗。

伤寒六七日、发热微恶寒、支节烦疼、微呕、心上支结

①、外证未去者、柴胡桂枝汤主之、（146）

注：“心上支结”《宋本》作“心下支结”。

桂枝去皮 黄芩一两半 人参一两半 甘草一两炙 半夏二合半洗 芍药一两半 大枣六枚擘 生姜一两半切 柴胡四两

右九味、以水七升、煮取三升、去滓、温服一升、（注）

本云人参汤、作如桂枝法、加半夏柴胡黄芩、复如柴胡法、今用人参作各①半剂、

注：《宋本》无“各”字。

胡希恕：刚才说了，少阳病不能发汗或泻下，但并病的时候，可同时用，这也是定法。大柴胡汤就是少阳阳明合病，是柴胡证，里也实了，所以给大黄，那么此段是少阳与太阳并病，有太阳病，少阳病也发生了，把二方放在一起就行了，用柴胡桂枝汤。此段说明，伤寒六七天的时候，全是由表传入半表半里或里，发热微恶寒，表不解，支节烦痛也是太阳病，微呕，心下支结，支是树枝，是旁边，不只是心下的部位，二侧谓之“支”，心下二侧，心下支结就是心下苦满的另一种说法。微呕，柴胡证喜呕，微呕，心下支结皆为柴胡证，上面是表未解，太阳病，故用二方合方。

一般在临床上，少阳病不能发汗，不能泻下，但有表证，太阳少阳同时用药是可以的。如用小柴胡汤配发汗药可加薄荷、桑叶、菊花都行的。表证需要发汗，用柴胡桂枝汤非常好用。小儿感冒常有此种情况，既有恶寒之表证也有柴胡证，这里用柴胡桂枝汤就得了，只是用发汗药而不用柴胡是不行的。这是定法，此书上有例子，把二方合在一起是治柴胡桂枝共有的证候，就是合并证，支节烦痛，身体疼痛皆为桂枝汤证。

桂枝、黄芩、人参、甘草、半夏、芍药、大枣、生姜、柴胡、是各半汤，桂枝汤减半，黄芩、甘草原二两，现为一两，半夏原为半升，现在二合半，桂枝没有分量，也应是一两半，柴胡给四两为原来的一半，人参一两半、生姜一两半，都是给一半，就是各半汤，柴胡桂枝

汤就是柴胡一半桂枝一半，既有柴胡证，又有桂枝汤证，可以把二方合起来。

李冠杰：这个条文在《康平本》里面是顶格的条文。

条文里面“心上支结”在《宋本》里面是“心下支结”。

“伤寒六七日”，患了太阳表实证日期比较长，疾病具备了发展变化的可能性。

“发热，微恶寒”。“发热”是太阳病和少阳病共有的一个症状，“微恶寒”本身就含有表证的程度有所减。“微恶寒”就跟“恶寒”做了一个程度上的区分。实际临床当中很难准确地判断这个“微恶寒”，有的人很可能口干、口苦没有恶寒的感觉，这也是常见的，不一定会出现这种情况。之所以说“微恶寒”，就是想说明：一个是表现不像单纯的太阳病“恶寒”那么严重，这是其一。另外一个就是太阳病的程度，没有单纯的太阳病那么明显。

实际上，真正实践在临床当中，你看到这种病人的时候，你真的要仔细地去权衡，到底有多大成份的表证？有多大成份的半表半里证？尽管治疗起来以后差别不是很大。

“支节烦痛”，这儿的这个支，跟肢体的肢是通用的。那么“肢节”就是指的四肢的关节了；“烦痛”就是因为疼痛而致人感觉到烦。这个属于表证的范畴。

“微呕”，这是典型的少阳病的症状反应。“微呕”什么意思啊？有少阳病的症状，但是少阳病的症状程度不很严重，或者不是特别得明显。实际上少阳病不呕的有得是。那么“微呕”，可以去延伸啊，“往来寒热”也可能有，也不很明显。心烦，烦得也不是特别厉害。大家读经方的书呀，不能“死于句下”，就应该活着读。

“心上支结”，这个“支”跟前边那个“支”不是一个意思。这个“支”，是指的支撑的意思。胡老解释这个“支”呢，是两侧往两边撑。你要是理解成由下往上撑啊，感觉“由下往上”也能通。因为

这里边含有桂枝汤，有气上冲的一种趋势。这个“结”就是结聚的意思。“心上支结”呢，就是患者自己感觉到有支撑闷结的感觉，类似于柴胡证的胁下满之类的症状吧。但是“心上”肯定不太合理。“心上”嘛，就是心脏以上，如果从心脏再往上看的话，就到颈部和肩部这一块儿。跟这个方剂所治疗的适应证啊，相差就比较远了，在临床当中你也很少见到这一类的症状。所以说《宋本》的“心下支结”反倒是比较贴切，就是胸胁的部位有“支结”感。胡老的解释是两侧。胸胁，胁部本身就包括了侧面。

“外证未去者”这一句话挺有意思，想说一个什么问题呀？桂枝汤证其他的症状，而且还可能不止一个。所以这儿用了“外证未去者”，这一句话全都概括进去了。那么为什么这个地方单纯说出了“外证未去”？经方里边不是有一个说法嘛：“少阳证，但见一证便是”。但是表证不一定表现为发热恶寒的，也许会表现为其他的表证啊，没有关系，只要是表证，都可以算。但是如果是典型的表实证的话，那就值得注意了。可不可以用小柴胡汤合上治疗表实证的方剂呀？也未尝不可。

这个条文里边还有另外一个特点，条文里边列举的这些症状，在这个方证里边出现的频率并不是最高的，换句话说都不是特别典型的症状反应。为什么非得把一些不太典型的症状列举在条文里边呢？因为，如果不在这列举的话你是想不到的。你一看到柴胡桂枝汤，就是小柴胡汤和桂枝汤的合方，你首先想到的就是小柴胡汤证的症状反应和桂枝汤证的症状反应。但是有时候，这个病人处在两类疾病同时存在的时候，表证的症状反应也不是那么典型，半表半里证的症状反应也不是那么典型，他表现出了一些比较特殊的，这儿就恰恰给你说了那些比较特殊的，带有特征性的，但是并不一定是最常见的。

还有另外一个问题，我们不要单纯地把它看做就是两个方剂合到一块儿，或者说是治这两个方证同时发生的这一类的疾病。不要放到

这么浅的位置上去认识，再稍微高一点的认识。怎么高一点的认识呢？就是教读者，一旦遇到这两种不同类型的疾病同时发作的时候，在这个地方给你做了一个示范。你可以举一反三，而且同时这里边还蕴含了经方的治疗原则。

太阳病是可以发汗解表的，但是一旦有了少阳病的存在，就不能单纯地用发汗剂了，必须太阳和少阳同时来治疗。如果我们再进一步地、深入地再去整体地来理解的话，虽然有可能存在着桂枝汤证的所有的症状反应，一旦有柴胡证，“但见一证便是”，疾病的主要矛盾随之发生变化，由以太阳病为主要矛盾，一下子转为以少阳病为主要矛盾。这个时候太阳病已经不重要了，如果碰到这一类的病人，单纯的让他吃小柴胡汤行不行，完全可以。他半表半里证好了，可能表证好不了，有时候表证也可能会好。但是他常常会剩一点表证好不了，这时候再去解表也没问题了，对人体没有危害，只是这个治疗过程会变得长一些。但是如果反过来，你要是单纯的先解表就不行了。这里边不仅仅蕴含了经方的治疗原则，而且可以从中体悟人体生理、病理的一个规律。一旦有了更深层次的疾病，特别这个疾病是个虚性的，你非得解决它不可。假设要再见到阴证，这个都可以不治，而先要去治阴证。

下边呢做个小结：

患伤寒六七天的时间，患者表现为发热，微恶寒、肢节烦痛、微呕、心下支结，而且表证仍然没有解除的，为柴胡桂枝汤主治之证。

那么，在这儿说几个临床当中我自己的治疗医案。但是我想是这样，谈医案就尽可能避免误导。因为医案很容易被人接受，所以也容易给人造成误导。我这儿就有两个鼻炎的医案，但是你千万不要以为柴胡桂枝汤就是一个治疗鼻炎的特效方。你不要这么认为，他得有这个“方证”。

其中一个医案，我和一个也算是个朋友的吧，参加婚礼坐在了一

个桌上，寒暄过程当中他就说：“你给我看看吧，我这个病不大，但是挺痛苦”。我说：“怎么着了”？他说：“我这个鼻炎哪，多少年了吧，二十多年了。为了这个鼻炎，我经过多少次治疗都数不清了，有西医的治疗，也有中医的治疗，其中还包括了打了两次激光”。我在饭桌上没事跟他聊，还没喝酒的时候就号号脉，然后我就跟他说：“这样吧，我给你弄点药”。他呢实际上就是典型的柴胡桂枝汤证，但是都不明显。不明显你怎么判断他是柴胡桂枝汤证呢？他偶尔有点吃的热点啊，或者说是环境稍热一点啊，他容易出汗，这是其一。再一个有时候刷牙的时候会恶心，有时候会觉得烦得慌，他有这一类的症状。而且呢，还有一个很重要的前提条件，他不存在其他类型的疾病，至少是没有阴证。其他类型的，像阳明病，问问大便哪，看看舌象，问问口干不干哪，很容易判断，这些都没有。后来我就想，他就适合吃这个方子。我给了他五天的柴胡桂枝汤，他拿走药的时候大概两点多了。第二天上午的九点多，他特意开着车跑到我这儿来，他说：“你这药可真神了，昨天晚上吃了一次，这鼻子就透气了，然后今天早晨又吃了一次，这个鼻子从来就没这么透气过，从来没这么痛快过”。就这么五天的药吃完了以后，一直到现在，得有三年了，一直再没有出现过这个问题。这是一个医案。

前两天还有一个，这个病人啊在北京，这个小伙子大概二十四五岁吧，病人的母亲回家来办事，她家是夏津的，我们认识。后来她就跑到我这儿来跟我聊天，她就跟我说：“我儿子这鼻炎也不是一天两天了，得有好几年了，要经常用气雾剂喷，晚上睡觉憋得就影响睡觉”。我说：“我见不着病人，我没办法给药啊”。她说：“他来也不是一天两天就能来的，也得好几个月以后了”。我就慢慢问问，平时吃饭怎么样啊？大便怎么样啊？健康状态怎么样？后来我问来问去，也没有找着其他证的那种明显的情况。后来我就说：“那这样吧，我给你点药带着，你让他吃几天，看看怎么样”。给她不多，我觉得心里也

没底啊，见不着病人，就给了柴胡桂枝汤，大概能吃四五天吧。结果后来她给我打电话说：“孩子吃了以后，轻多了，也不用再用气雾剂喷了，晚上睡觉就没事了，他还想吃”。我说：“要不再给你发点吧”。结果我药做好了去发，发不出去了。现在在开十八大，进京的粉末的东西都不让发，结果没发出去。不过，中药是这样，不会停了药以后，马上就又复发了，也不至于。

还有，这个柴胡桂枝汤治疗小孩子感冒，包括一些成人的感冒，当然主要还是症状了，是个常用的方剂。前段时间也有这么一个病人，一个小女孩，不到 10 岁吧，主诉是发烧。摸脉，有点浮、有点弦、数，为什么？她发烧，体温高，脉不数嘛？问她：“这段时间吃饭怎么样？”说：“这段时间吃饭不太好，有几天了吃饭不好”。那么，这儿首先你就考虑，这是个小孩子，有柴胡证的可能性，顺柴胡证找吧，但是其他的就不明显，就是说也没有喜呕的那些情况。后来我说：“你刚感冒的时候，昨天，有什么特殊的不舒服的感觉吗”？孩子自己就说：“哎呀，那个冷啊，怕冷啊，觉得冷得厉害，但是一会过去以后，还热呢”。你看这不是往来寒热嘛？这有了。然后，那就去找她有没有表证这方面的，孩子有汗吗？她本身有一个发热了，她说：“睡觉以后有汗出”。好了，柴胡桂枝汤。第二天就好利索了。一天的时间吧，就好了。

另外，这个方剂里边就有一个完整的小柴胡汤，桂枝汤里边不还有一个“脏无他病，时发热汗出”嘛，这两个合到一块儿，会出现一种很特殊的情况，就是定时的出汗。那么什么情况？更年期综合征。

我这儿有一个挺典型的医案：这个妇女，五十岁多一点，正是刚刚闭了经。她那个更年期综合征啊，每天早晨四五点钟要出一大身汗。这不是定时发作吗？定时发作是一个特征。另外一个，平时打着打着电话，有点什么事，稍一激动，马上就要出一身汗，这不是特殊的因素造成她一定的症状反应，也是“发作有时”的一种。其他的症状不

是说特别明显，而且问那个像柴胡证什么的，几乎一概没有。就根据这个，后来我就给她吃柴胡桂枝汤。她那量给的比较少一点，吃到第三天，基本上就消失了，这些症状就没了。柴胡桂枝汤，这是一个比较常用的方剂。但是，我上边说的这个不是说这个柴胡桂枝汤是这种特效药，它得有这个证，至少她没有其他类型的疾病。

但是，值得注意的问题是什么？一是，这个药物的量的问题。这个方子实际上是小柴胡汤取了一半，桂枝汤取了一半。我们换一种方式来想一想，我们眼前有一升桂枝汤，有一升小柴胡汤，如果病人是一个柴胡桂枝汤证，那么你取半升的小柴胡汤，取半升的桂枝汤。这说明什么？没让你把这两升倒到一块全喝下去。这里边我们能看出一个问题来，经方的用药量基本上就是常规用药量的一个上限。当两个方剂合到一块的时候，这个药物的量就得减，从这也能看出来。你看桂枝汤多么平和的方剂啊，小柴胡汤一旦要和它合到一块，要各减一半，从这个地方我们能看出来，这是一个问题。另外一个，就是这个方剂合方的方式，从药量上看，与桂枝二麻黄一汤、桂枝麻黄各半汤那种合法不一样。那种合法是简单的相加，就是重复的药物把药量加到一块。但是这个方剂不是。凡是重复的药，只取一个方剂的，甚至像甘草这一味，取的还是一个量少的，取的不是一个药量大的。这儿呢就是说，为我们经方的合方，又示范了一条新的方式。

还有一个小问题，就是这个方后注解之后，有这么一段小文字：“本云人参汤，作如桂枝法，加半夏柴胡黄芩，复如柴胡法，今用人参作各半剂”。这一段文字，我们现在几乎可以说，是从别的地方误抄的，也不是，说的也是这个事。但是呢，跟这个地方，又不能完全对上号。历代的注家都不做解释。反正是这段文字让人感觉到很模糊。

咱们做一个小延伸，关于经方合方的药量算法的问题，这儿就形成了三种方法。一种方法是简单相加，桂枝麻黄各半汤那一类的；另一种办法是，重复药物取药量大的；还有一个就是这个方剂做的这个

示范，反倒是重复的药物取了药量小的，你仔细去看那个甘草。这三种方案变化就在这些重复的药物上。其他的方剂把道理讲通了，你就好明白了。但是，简单相加和重复的只取一个量的话，这里边差别就比较大。那么简单相加的话，生姜、大枣和甘草都翻了倍，要是里虚比较明显的病人的话，用这种方案完全可以。但是病人不那么虚的话，也没有必要按着这个原方，也不会影响疗效的，所以说这要活着看。那么其他的方剂在合方的时候，要再合上当归芍药散，当归芍药散里边芍药就很多，是不是有必要再去简单相加，如果芍药证不很明显的话，当归芍药散里边一斤的芍药量减一半都没有问题的。关键是只要知道道理，什么都是活的。

那么下面我们再看看柴胡桂枝汤的方证。

症状反应：发热、恶寒、胸胁苦满、头痛、口苦、腹痛、身疼、呕吐、头晕、食少、胁痛、胃胀。

舌质：淡红舌、红舌、嫩舌和淡嫩舌。

舌苔：薄白苔、薄黄苔。

脉象：浮弦的脉、弦数的脉、浮数的脉。

柴胡桂枝汤证病理状态下，有可能发生的现代疾病：胆囊炎，胆结石，肝炎，慢性肝炎，急性肝炎，肝炎后综合症，脂肪肝，慢性胆囊炎，急性胆囊炎，胆结石术后腹痛，癫痫，神经分裂症，神经衰弱，失眠，神经官能症，多怒，瘰病，耳鸣，输卵管结扎后肢体麻木，慢性胃炎，胃下垂，胃痛，胃酸过多症，胃酸过少，十二指肠溃疡，胃溃疡，急性阑尾炎，结肠炎，消化性溃疡，慢性胰腺炎，糖尿病合并慢性肝炎，肋软骨炎，心律失常，房性早搏，室性早搏，房室传导阻滞，病窦综合征，心房纤颤，胸痹，高血压，感冒，流感，小儿扁桃体炎，老年性慢性支气管炎，病毒感染性发热，更年期综合征，经前期紧张综合征，脂膜炎，急性心绞痛，胆道蛔虫，胃痉挛，肠痉挛，急性发作的胸腹痛，过敏性紫癜，紫癜性肾炎，夜半盗汗（顺便跟大

家说一下，特别是一些儿童啊，有盗汗的，往往有定时的这种特点，这个柴胡桂枝汤证的机会几率比较多），子时胸痹，急性胃炎，急性肾炎，急性泌尿系感染，面瘫，不寐，坐骨神经痛，无名高热，多囊肾发热，鼻炎，流行性出血热，术后肢体麻木，肺炎，肺结核，内膜炎，疟疾，眩晕症，胸膜炎，肋间神经痛，荨麻疹，夜尿症。

在同样的一个病理状态下，可以发生这么多类型的、这么多部位的、这么多不同性质的疾病。这里边就蕴含了一个规律，这是更深层次的规律。其他的医学解释不了，用脏腑辨证也好，或者是现代医学也好，根本就解释不了。

伤寒五六日、已发汗、而复下之、胸胁满、微结、小便不利、渴而不呕、但头汗出、往来寒热、心烦者、此为未解也。柴胡桂枝干姜汤主之、（147）

柴胡半斤 桂枝三两去皮 干姜二两 栝蒌根四两 黄芩三两 牡蛎二两熬 甘草二两炙

右七味、以水一斗二升、煮取六升、去滓、再煎、取三升、温服一升、日三服、初服微烦、复服、汗出便愈、

胡希恕：此方常用，伤寒五六日的时候，已发汗而复下之，此五六日的时候正是传半表半里的时候。表不解，没有少阳病的证候，发汗可以。但发汗表不解后要好好看一看，如果表不解用桂枝汤，不可吃下药，得辨证，如果表不解，泻下，总要使邪热内陷，胸胁满微结，胸胁满为柴胡证，微结，里面微有所结，结得不厉害。但是有所结，我们用柴胡桂枝干姜汤，就是个体会，各注家都没这么注，这个柴胡桂枝干姜利于大便干，这也奇怪，有人一看又有干姜，又有桂枝，就认为偏温，其实这个药，大便稍溏，用它是要泻的，所以微结，就是

里头微有所结，只是结得不象阳明病及结胸病那样结的凶。小便不利，渴而不呕，因反复下之，丧失津液了，所以尿不利，同时也有误下致气上冲的关系，导致小便不下行，故有二种原因致尿不利，故桂枝用量多，三两。气往上冲，诱使水上而不下，可致尿不利，渴而不呕，微结，胃里头有热，渴，胃里头没有停水，故不呕，胃里头没水有热，但头汗出，气冲于上，气往上行而不下，所以但头汗出，往来寒热，心烦者就是有热，往来寒热就是柴胡证，是为未解也，未解也，有二个问题，一个多少有表证，一个少阳病里头微有所结，仍以柴胡为主治疗，此方合用桂枝甘草多少有解表哇。在临床上有无名的低热，用此方很好，没有其他的表证，但现些柴胡证，我用此方治低热，治的很多，找不出来什么原因，如肝炎低热的用此方可解除。此方与小柴胡汤不同，里头不虚，不用人参，不呕，也不用半夏，但是渴，所以用花粉、牡蛎，刚才讲了，此二药解渴的力量很强，同时微结，这个花粉、牡蛎，花粉本身有润下的作用，再加上咸寒的牡蛎一起，有通大便的作用，用桂枝甘草汤治气上冲，里不虚，而不呕，渴，有时气上冲，有微发热，即有表证，此方可以用的，其它的与柴胡证大致相同的，柴胡用的也相当重，半斤，即 24 克，花粉也量大，此药苦寒治消渴，解热有缓下的作用，对宽胸作用不如瓜蒌实，去痰宽胸就用瓜蒌，去热解渴，用花粉。这个方子，在柴胡剂里头，慢性病用都好，为什么？花粉这个药是个补药，有点强壮作用，常用滋阴，久病虚衰无力，心下多少有点满，满有二个问题，一个为有所结，一个为气上冲，用桂枝甘草，有人看桂枝干姜热得不得了，其实桂枝我常用并不那么热，不象现在教材说的桂枝是大热药，其实这个药最平稳不过，不是那么热。

李冠杰：这个条文是顶格的条文。

下边解读一下：

“伤寒五六日，已发汗，而复下之”。这儿论述的是患了太阳病

时间比较长了，本身就说明人体的抵抗力有限，但是又经过了发汗和泻下的治疗，病还没有治好，而又发生了新的疾病症状的这么一种情况。表证发汗不愈以后又使用下法，前边的条文中有这样的误治，但是那些地方出现的不是柴胡桂枝干姜汤证，这个地方到了太阳病后半部的条文了，都是一些比较特殊的情况。“伤寒五六日、已发汗”，伤寒五六日不是正应该发汗吗？这个“复下之”是后边又用了下法，为什么？这里边就隐含了一个事儿，虽然是太阳表证，但是发汗以后并没有好，要好了不可能再用下法了。没有痊愈的原因是什么呢？不外乎两个原因：一是病比较重；第二个就是方与证可能不相适应。但是不管是什么样的情况，先发了汗，病没好又用了下法，都是不合法的治疗。结果肯定是对人体影响比较重，就是发了汗以后再下了，人体就比较虚弱了，这时候就容易发生一些情况比较重的新的疾病。

看看会发生什么样的疾病呢？“胸胁满、往来寒热、心烦”。这个都是少阳病的症状反应，说明这个时候人体有半表半里的热证了。

“微结”可以理解成是有轻度的里实证。胡老对微结的解释说它表现为便秘，但是实际临床统计资料中，还有其他的人主张这个方剂会出现便溏，咱们学完了以后大家就明白了，都有可能出现的。

“小便不利”。结合这个条文就有两方面的因素：一个是经过上面的误治，发汗损失了人体的津液，泻下又损失了津液，造成人体津液虚；第二个是误治又造成人体体液代谢方面的一些障碍。这两方面的因素都有可能存在，而造成小便不利。

“渴而不呕”，因为津液损失比较重，胃中津液虚就表现为口渴，水分少了就没有停饮，一般情况下就不呕。

“但头汗出”。这一方面是里有热，里面有热想用出汗的方式散热；另一方面是体液代谢上有点失常，津液又虚，这时候又影响汗出；同时又有气上冲的因素存在。所以仅仅的表现为头上有汗，其它地方没有。

旁注：“此为未解也”。这完全是一句没有用处的话。大家想想，不管前边怎么治，现在还存在着一大堆的症状呢，谁要认为是要解除的那个病，那不奇了大怪了？像这类的注解真是水平太差了。

但是“柴胡桂枝干姜汤证”是比较难以解释它病理的一个方证，历代的注家解释差别也比较大。咱们看看胡老怎么说的，胡老说这个方子在柴胡剂里头，慢性病用都好。为什么？花粉这个药是补药，有点强壮作用，常用滋阴，久病衰弱无力，心下多少有点满，这是胡老说这个方剂应用的一个特点。

陈慎吾老师认为这个方剂有“阴证转机”，这一点也非常重要，记的以前跟大家说过这个事。当时陈慎吾讲课时讲到方剂有“阴证转机”，下面听课的学生里有后来成为经方大师的刘渡舟，他也觉的不好理解，下了课以后刘渡舟去问“阴证转机”是什么意思？陈慎吾老师没有正面回答他。有这么一个小插曲。

总的就是说，这个方证从病理角度分析不太好理解。像柴胡桂枝汤证就是少阳病和太阳病合病，让人感觉比较简单，少阳病就是小柴胡汤证，小柴胡汤证有什么样的特征？桂枝汤证有什么样的病理？两个的病理合到一块儿就齐了。但是“柴胡桂枝干姜汤证”不是这么简单了。

如果按照病理辨证体系来分析，就容易看到这个方证属于一种比较复杂的病理，条文里论述的那个病因，就是为了出现这种复杂病理所做的铺垫，或许临床有这个过程，重在强调人体本来就弱，又发汗、又泻下，把人折腾的已经近乎于阴证了。从疾病类型上，咱们既要结合条文里论述的症状，同时又要结合方剂里的药物，它既有表证，也有半表半里证，还有里证，因为有“微结”嘛！同时还存在体液代谢不调，这用的是“不调”，不是“不良”，不调是说它既有津液虚的一面，还有停饮的一面，津液虚与停饮同时出现。像五苓散的实质是因为停饮太厉害了，反到是造成了人体缺少水分，但缺少水分不等于

是津液虚，这里面就有个辨证关系。从疾病的性质上分析，它既有寒热错杂，方剂中桂枝、干姜是典型的温药，都是可以治疗虚寒证的，柴胡、黄芩、瓜蒌根、牡蛎都是比较典型的清热药，所以说它的病理上必然存在寒热错杂；它同时又有虚实错杂，虚是一个主流，但是里边还错杂着实，“微结”嘛！有时常常临床也会表现大便不通的情况；而且还存在着阴阳错杂的情况，这个事儿让人感觉到中医的阴阳观点里不应该有这种情况，但是胡老在临床中常把它用来治疗慢性病，还有陈慎吾总结有“阴证转机”，实际上都是指的这类情况。我在临床上应用这个方剂也有这种体会，凡是用这个方剂疗效比较好的病人，还真是你说它是阴证，它就是一个阴证的，体质又弱，或者说年老多病这一类的病人。但是这个方剂里没有附子，实际上栝蒌根在里边起着挺重要的作用，下面我们会再讨论一下。

做一个小结：患太阳伤寒五六天的时间，已经用过发汗的方法治疗，因不愈又施以下法，患者表现为胸胁满，微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦的，为“柴胡桂枝干姜汤”主治之证。

这个方剂有七味药组成：柴胡、桂枝、干姜、栝蒌根、黄芩、牡蛎、甘草。柴胡、黄芩可以解半表半里的热；桂枝、甘草本身就是一个方剂，它可解太阳表证，也能降气冲；干姜肯定是温中补虚了；栝蒌根和牡蛎同用，有比较强的止渴作用，在《金匱要略》里有一个栝蒌牡蛎散，这里就等于包括了这个方剂，用来治疗“百合病，渴不瘥者”，也就是说患百合病，以口渴为主要的症状反应，百合病本身就是一个虚证，可见栝蒌根它有比较好的补虚作用。

在这个方药中，“栝蒌根”值得我们注意，对它的药性不同的医家说法不一。胡老是这样解释的：栝蒌根所主之渴，由津液枯燥所致，即所谓虚热证，故常伴有疲劳倦怠的证候，与石膏所主之渴不同。但是也有人认为这个药可以祛痰饮，《中医辞海》里是这么说的：性寒、

生津、止渴、降火、润燥、排脓、消肿。《中医辞海》是比较权威的典籍了，但是对栝蒌根很重要的一个“特性”没有体现出来。虽然从不同的角度对这味药认识不尽相同，但是从这个方剂在经方的应用看，它有下面几个功能是比较确定的：一是它是寒性药；再一个它有止渴的功能；另外一个它有“补益”作用，这一点非常重要。大家去看一看吧，所有含有栝蒌根的方剂都存在着人“虚”的问题。

下面是这个方剂的统计资料。

临床中在“柴胡桂枝干姜汤证”病理状态下，常常会出现下面这些症状：往来寒热、胸胁支满、心下悸动、自汗、食欲不振、口渴、胁痛、神疲乏力、大便不调（包括了便溏与便秘）、小便不利、眩晕、腹胀、口苦咽干、恶心、失眠、形体消瘦、腹痛、肩背酸痛、喘促、头痛、心烦。

舌质：是以淡舌为主。

舌苔：以白苔为主，还有薄黄苔、有黄腻苔、有黄白相间，这明显的能看到错杂性。

脉象：是以弦脉为主，其次是细脉、沉脉、数脉。

在“柴胡桂枝干姜汤证”的病理状态下，可能会出现的现代疾病：胃及十二指肠溃疡、胃下垂、慢性胃炎、胃酸过多症、慢性结肠炎、急性腹膜炎、急慢性胆囊炎、胆结石、胆道感染、急慢性肝炎、肝硬化、流感、疟疾、无名高热、急慢性肾炎、肾盂肾炎、肾病综合征、尿毒症、泌尿系感染、老年尿闭、神经衰弱、癭病、神经质、癫痫、肺炎、肺结核、慢性支气管炎、肺门淋巴腺炎、胸膜炎、肋膜炎、附件炎、乳腺肿瘤、乳腺增生、月经不调、子宫功能性出血、急慢性中耳炎、头部湿疹、疖肿、结膜炎、甲状腺肿大、糖尿病、美尼尔氏综合征、阳痿、放疗后胃酸缺乏症、特发性震颤综合征、瘰癧、黄疸、结核性腹膜炎、不眠症、更年期障碍、神经官能症、心悸、亢悸、蓄脓症、耳下腺炎、口吃、头疮、紫绀病、产褥热、湿疹、过敏性皮炎、

淋巴结核。包括的现代病也不少。

伤寒五六日、头汗出、微恶寒、手足冷、心下满、口不欲食、大便硬、脉细者、此为阳微结·必有表·复有里也·脉沉亦有里也①·（注）汗出为阳微·假令纯阴结·不得复有外证·悉入在里·此为半在里半在外也·脉虽沉紧·不得为少阴病·所以然者·少阴不得有汗②·今头汗出·故知非少阴也·（经）可与小柴胡汤、设不了了者，得屎而解、（148）

注：

1. “脉沉亦有里也”《宋本》作“脉沉亦在里也”。
2. “少阴不得有汗”《宋本》作“阴不得有汗”。

胡希恕：伤寒五六日的时候，头汗出微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便硬，这么一种证候，头汗出，微恶寒，即表不解，手足冷，心下满口不欲食，是柴胡证，是半表半里的一种情况，大便硬是里头有所结，脉细者此病既有表不解，但表很轻，半表半里也有，这个证候也不很明了，没有胸胁满只是心下满，偏于里，口不欲食，象柴胡证，大便硬是里实了，但脉不大，脉细，故叫阳微结，即阳明的微结证，这与上面那条有关系，即与“胸胁满微结”有关系。解释阳证的微结与寒湿结胸。根据此证候手足冷，又微恶寒，这种大便硬有寒湿结的情况，故要分析，阴证的那种寒湿结，整个邪郁于里它没有表证。那么微结，太阳证还没罢，它一定有表而又有里，那么就分析上边了，这个微恶寒就是表不解，那么底下这个呢大多都属于里边的病，尤其由于汗出，这是阳微证的一种明确的反映，这个汗出，尤其是头出汗，都是热往上冲的表现，假令是纯阴结，那种阴寒的证候它不得有汗出的这种外证，悉入在里，外边不会先有热象的，此为半在里半在外也。那么就上边的证候说，俨然半有表证，半有里证的这么一种情况，虽脉沉细，少阴之为病，脉微细，但欲寐，那么这个是

微结于里，脉沉，虽脉沉细，这也不是少阴病传里而为太阴病的那种情况。所以然者，阴不得有汗，阴证没有外边有汗这种情况。阳明病发汗出，虽然是头汗出它也是热象。今头汗出故知非少阴也，少阴没有头汗出这种情况。那么上边的这些就是既有表又有里，就是我刚才说的口不欲食，有些是柴胡证，所以可与小柴胡汤，它也说的是“可与”，还要你斟酌，这个小柴胡汤这个药啊，大概后面也有，它也可以通大便。柴胡这味药它对于疏泄胸胁这个部位很有用，它不是升提，后世医家都说它是升提，它不是升提，它就起疏泄作用，尤其是瘀血证我们常常用小柴胡汤，尤其是大便干，后边不是有这么一句：上焦得通津液得下。结于胸胁也就是热与津液结于上，它不往下行，吃小柴胡汤，上焦得通，津液得下，胃气和也能对微结证起作用。那么如果使用小柴胡汤而不了了者还有大便硬，上边这个证候虽然减轻而不了了，不是整个去了，那么这个时候得屎而解，可以在小柴胡汤里有加大黄也可以，稍稍与调胃承气汤也可以，这个他也没指出来。总而言之，这个活动口气在仲景这个书都是让你在临证中加以分析的，让你辨证。这一段呢也都给搞错了，主要的上边提出的胸胁满微结两个字，它的口气有这么一段，那么这个微结的时候用小柴胡汤是可以解决的，但结的甚那就柴胡解决不行了，起码来个大柴胡。如果没有柴胡证，柴胡也不能用了，这个柴胡也不是万灵的药，没有柴胡证用的是有害无益，所以还是要辨证的。那么大便硬，心下满，又有里，这个病要在我们临床上很难辨，又有微恶寒手足冷，脉微细，假设在临床上遇到这个病，你想不到用柴胡汤，是不是？那么为什么可以用柴胡汤呢？我们看一看，它这个主要是口不欲食，它前面不是说了吗，柴胡证但见一证便是，不必悉具，这个病主要是这么几个方面你得辨证，这个辨证不象咱们现在的辨证，这儿虚，那儿虚，瞎扯一大堆，主要是你得看应该看从哪一个，仲景最终极的辨证是方证，那么哪一个方子适应，就是这个意思。这个不欲饮食，就是默默不欲饮食，就

是小柴胡汤证。那么当然这个是有表又有里，少阳病又忌汗又忌下，所以见要是柴胡证它既有表又有里，所以他用小柴胡汤是最合适，但是他用一个“可”，可与小柴胡汤，没说小柴胡汤主之，那么道理在那呢？这个证不是那么全备，不是柴胡汤证具，不是那么全备。这一段在临床上也常遇到这种病，病人呢是表里错杂不爱吃东西，这个一般的严重的感冒也常有这种情况，但是这个脉细，脉弦脉细，这都是近乎柴胡证，它不是太明确，它只是口不欲食，那么这一段呢，这个口不欲食上次我讲了，这个柴胡证可以是口不欲食，默默不欲饮食，就是昏昏然的不愿意吃东西，精神不好。那么，在阳明病里，咱们还没研究，阳明病里有热，热结于里，里头有热，它能食，阳明病，能食者为中风嘛。但是它要是内里有结得相当厉害了，它就不能食。那么这个呢，它要是真的结得厉害了，不光是头汗出，阳明病是法当多汗，那身上是不断汗出，蒸蒸汗出。那么结得厉害它小便也数，手也汗出，甚至是谵语，这个它都没有，阳微结，结得非常轻可见这口不欲食它不是阳明病，它是少阳病，所以他用可与小柴胡汤。这个小柴胡汤呢，我对于它的认识，它有一个疏泄的作用，咱们现在说的疏肝那，它不光是疏，它也有缓下的作用，后面阳明篇有，所以胸胁满，大便要是不通，与小柴胡汤，这个是上焦得通，津液得下，胃气因合，这个胃气不合，小柴胡汤咱们开始就讲了，小柴胡汤它既是解热剂，它又可以健胃安中，所以它里面有人参嘛。但是柴胡大量用，柴胡这个药有些疏泄，也能通大便，所以《本经》上说是推陈致新啊，那么如果是上有些热结，它只是心下满，这都是上边，对于胸膈这个地方有所结滞，柴胡就都疏泄了。所以小柴胡汤对于胸胁苦满，它是通上焦，这块儿有所结滞，津液它不下，所以柴胡汤使津液可以下的去，大便也通。由这一段咱们也可以看出小柴胡汤它也有通大便的作用。所以我们在临床上治感冒日久不了了，这种情形咱们是能遇到的，就是不爱吃东西，自己量的体温还挺高，这个时候啊，表和里，既有半

表半里证，又有柴胡证，不能用汗法啊，下啊，不能用，所以这一段在临床上很重要。那遇到这种病，脑袋出汗，恶寒很轻了，微恶寒，手足冷，容易看成是阳虚啊，容易看成是这个，但是呢底下又有大便秘，大便燥结，所以你得全面看问题，这个病很不好措手的，那么它说可与小柴胡汤，实在不好了，得屎而解，这个得屎而解也是比较含蓄的话，就让你临证适应用药，也可以小柴胡汤加点儿大黄啊，或者用小柴胡汤加芒硝啊，或者用调胃承气汤啊，稍稍的用啊，得屎而解。所以这一段是很重要的，上次我讲时没有这么详细解释。我们这么看张仲景的辨证啊，他不但辨六经，六经是六个类型同时它无一不在八纲中下手，你看看这就是表、里、阴、阳、寒、热、虚、实，就是这个东西，它不象咱们现在的这个辨证。所以读他的这个书搞出很多门派不同，这东西就是各有所见。你看他这个书，它一样样排除。它肯定就是阳微结，从大便秘，心下满来看问题的。也就是说这个微恶寒不是阴证，就是表不解。手足冷呢，它是由于卫虚，津液虚，不达于四末，手脚就凉，也不是什么特殊的身寒。头汗出呢就是阳亢于上，它就是辨的寒、热、虚、实、表、里，就是这个东西。然后在六经上看就是既有表，又有里，又有柴胡证，就是少阳证半表半里都有。那么要是都有的话，表里半表半里，它从中治这是对的，由于少阳正是忌汗忌下，用小柴胡汤是非常好的。所以他用一个“可”，由于这个证它不太具备。所以他的论治是非常有分寸的，那么这个呢，要求你在临床上还要细辨。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边应该说是它整体是个顶格的条文，但里边加了很多注解内容。注解内容的“脉沉亦有里也”，在《宋本》是“脉沉亦在里也”有一个字的不同。嵌注里边“少阴不得有汗”，在《宋本》里边是“阴不得有汗”，没有那个“少”字。

下边解读一下：

因为这个条文当中所包含的注解内容太多了，注解内容比原文内

容文字量还大，真正想解读原文的本意，咱们先用一个减法，把嵌注和旁注的内容先剔除出去，先对原文内容进行一个解读，然后再对注解内容也做一个解读，把它分开来理解。这样把注解内容刨除去以后，剩下的内容是什么啊？

这个条文就成这样了：“伤寒五六日、头汗出、微恶寒、手足冷、心下满、口不欲食、大便硬、脉细者，可与小柴胡汤；设不了了者，得屎而解”。

按我们前边学习条文的那种惯例，从他列举的症状入手，你会发现什么啊？我们很难通过这个症状跟治疗方剂，就是小柴胡汤联系起来。所有这个条文里边所列举的这些症状，它都不是某种疾病的典型的症状反应。换一种方式来理解，从临床这个角度来看，我们就把这个条文看作一个医案。

“伤寒五六日”先别管它，因为经方里边重证，不重病因。大家看这个条文成了什么了？不正好是一个医案嘛。只是没有年月日、没有姓名、没有年龄，再把“可与小柴胡汤”之后的文字、治疗的办法去掉，剩下的这个就是医案里边记录的症状反应。我们想象：临床当中我们碰到这样一个病人，主诉说：我平时老是怕冷，吃饭不好；平时手脚常是凉的，胃里边老觉得满，影响吃饭；大便也不好、大便有点干。那么你摸摸他的脉，脉有点细，不就是这么一个病人嘛。可是就是这样一个病人的话，你给他断定一个方证的话，如果没有条文的提示，我们不太容易把这些症状跟小柴胡汤联系起来。

我们先对它进行分析一下：

“微恶寒”就是我们平常常说的“怕冷”；“手足冷”，就是手脚凉；“心下满、口不欲食”，就是消化不好了，食欲不振，平时不愿意吃饭这一类的；“大便硬”，就是我们平时常说的便秘；再加上“脉细”，这个脉细说明人体偏于气血不足了。

主诉以这样为主的一个人，如果坐到我们面前，他会是一个什么

样的人呢？我在这儿形象的给大家说，如果在古代就是那种足不出户，素体虚弱的闺中小姐。现实生活中就是典型的亚健康状态，而且是体质比较弱的，年轻的女性比较多。大家想一想是不是这样？凡是有临床经验的，如果这么去看的话，你就会发现，这就是说的这一类的人。这样的人条文里边用的是小柴胡汤，用小柴胡汤的道理在哪儿？

看这些症状：前边有一个“伤寒五六日”，这里边应该侧重于理解哪方面的含义呢？就是说这个人感冒好多天了，人体患了表证以后，在人体的抵抗力和疾病作斗争的过程中，抵抗力没有胜过外界的致病因素，败下阵来。像这一类的情况很多，我们前边的条文里边论述了很多了。这儿讨论的是人体就是处于一种比较虚弱，各方面的功能都不怎么好，但是又没有、最起码还没有到阴性证的程度。

“头汗出，微恶寒”实际上有表证的成分，结合前边的病因，感冒已经好多天了，有疾病发展的趋势，或发展为阳明病；或发展为少阳病；或者发展为阴性病。但是这儿整个条文里边看不出它有明显的阴性证，特别是结合治疗方剂，它还到不了阴性证那个程度。那么这个“微恶寒”，就是因为已经进入了半表半里的证了，所以说表证恶寒的那个程度就没有那么重了。

“手足冷”和“脉细”，就是里虚，机能不足的一种病证。小柴胡汤本身就有里虚证，但是这个里虚相对说比较重了，影响到人的循环，脉也细了，手脚也凉。

“大便硬”，应该这么理解：如果说这是一个小柴胡汤证的话，那么这个大便硬，就是津液滞留于胸胁，不得润下。条文里边不是有“上焦得通、津液得下”，这分析的也是比较有道理的。

“心下满、口不欲食”，这是一个很重要的症状。从这个症状表现上看，就是胃肠功能偏于低下，消化吸收不良，而且同时它又是造成其它诸多症状的一个原因。它既是一个主证，而且同时又是造成其

它症状的一个原因。更重要的是它是应用小柴胡汤的一个重要的依据，它基本上类同于小柴胡汤证中的“默默不欲饮食”。

虽然说像上边论述的这些症状，你要在临床当中，会感觉到比较乱，比较杂，不太好辨证，但是我们在生活当中这却是一个很常见的一种病。我就碰见过这样的小女孩，大便不但是硬，而且常是很多天才能解一次，然后手脚凉，摸摸脉也细，就是这一类的情况。如果说我们把思路再拓宽一点，再结合第 147 条参照一下的话，这两个方证都是属于都有多种的疾病类型，既涉及到里，也涉及到表，而且主要还是半表半里；同时又有多多种疾病性质错杂，既有虚，也有实，甚至像柴胡桂枝干姜汤，有点偏于阴证，多种因素错杂在一块。但是两个方剂比较一下的话，咱们就不难发现：柴胡桂枝干姜汤的那种人，比咱们这讨论的小柴胡汤证的人啊，虽然临床当中表现的症状都比较复杂，但是相对的说，小柴胡汤所主的这种人的体质要比那种好一些。

所以胡老说：在临床当中柴胡桂枝干姜汤常常用于老年慢性病患者。而小柴胡汤用于青少年的机会就比较多，这讨论的是青年人出现这种情况的比较多，特别是青年女性；实际上小柴胡汤用到儿童身上的机会也非常多。儿童跟青年有一点区别，儿童属于五脏六腑还在发育的阶段，比较容易出现不协调的情况。但是在临床当中，你要是真碰到这种病人的时候，假设说你是一个经方爱好者，临床的经验不是很足，遇到这种病人的时候，你会觉得有点找不到一个主攻方向。比如这个病人来找到我，主诉：“平时怕冷，手脚凉”。你会想到什么呀？常常会首先想到的是阴证，是四逆汤证，这是常见的了；再加上你摸一摸脉，比较细，再稍沉一点，好了，你就觉得这差不多了，就是一个四逆汤证。当然像这种情况，你要让他吃了四逆汤，也不会有大的问题，但是你去不了他这个病。如果病人主诉是：食欲不振，不太愿意吃饭，食欲不好，好多都是家长带着孩子，就说哎呀我这孩子，整天吃不了多少东西，天天跟神仙一样，要让他吃点东西可费劲了，

再加上手脚也凉，看看人的体质比较虚弱，往往会把它辨成里虚寒证。比如他再有一点表的情况，可能会辨成理中汤证，表证要是重，也许你会辨成桂枝加附子汤证等等，都会出现这样的情况，而且你还会感觉到辨的挺对，怎么看怎么像。

这个条文之所以专门对这类的情况做了论说，就是为了避免出现这类地误诊的情况。这些都是咱们经方里边论述的都是比较典型的一些病理状态，古代就有这样的人，现代这样的人更多。

治疗就是用小柴胡汤，像这个典型的症状就这么一个，可以套上“默默不欲饮食”，但是临床当中可以用排除法，如果你怀疑是里虚寒证的话，他这大便硬啊，里虚寒证个别的也有大便硬的，但是非常少，而且无论是脉象，舌象都会有一定的区别。本身这个症状就比较复杂一些，很难把它说的很精确，后边留了一个小尾巴，就是说：“设不了了者，得屎而解”。也就是说像上边论述的这种情况，要如果偏于里实热的话，当时小柴胡汤证比较明显，吃了小柴胡汤以后，症状有所缓解，也没有完全好，留下一个大便的问题，大便不得通。像这种情况下，你比如说在小柴胡汤的基础上加上些通便的药，或者加大黄啊，或者加芒硝啊，或者给调胃承气汤啊，或者用麻子仁丸啊，这个麻子仁丸像这类的人应用的机会常常会有。正是因为这个条文里边列举了这么多的症状，但是所有的症状几乎都不太典型，凡读这个书的人，都会有一些感觉和疑问，感觉论说的不够确切，从这本书成了以后，我们见到的最原始的就已经开始对这个条文注解了。

咱们再看看旁注的内容：“此为阳微结，必有表复有里也，脉沉亦有里也”。他的大致意思就是顶格条文列举的这些症状，属于轻度的阳性的微结证，而且病情也比较复杂，既有表又有里。这个嵌注的作者加入的内容就更多了，论述的也比较详细。那么这个嵌注的重点论述的是什么？他论述的就是这种小柴胡汤证与阴性证的鉴别，并且对这个少阳病的病理做了一个明确的定义，对于临床当中的应用有些

实用价值。

但是这个论述里边有一个像“少阴不得有汗”，这个论据咱们值得研究。事实上，阴性证也常有汗出这个证，比如少阴病的桂枝加附子汤，就是以汗出为主要症状反应的，怎么能说阴性证没有汗哪？包括四逆汤证，人都有时候可能会出虚汗的，这个论点值得推敲。其他的尽管论述的篇幅比较大，但是相对的说要点不是很多，也不是特别的重要。但是当它被篡入正文以后，历代的注家都把它注得非常详细，实际上原文本身就是咱们前边学的那个样子。

下边做个小结：患伤寒病五六天的时间，患者出现头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便硬，脉细的可与小柴胡汤治疗；如果服药后仍有些余证不愈，则采取通大便的方法就可治愈。

旁注是说，正文论述的这种情况属于阳微结，既有表证也有里证，如果脉沉的话，也是属于里证。嵌注说的就是汗出属于阳气微弱，并非阴性证，假如是单纯的阴性证的话，就不应该有表证的存在，而是完全表现为里证。这个条文论述的情况属于半在表半在里，即使是脉沉紧，也不属于少阴病。

伤寒五六日、呕而发热者、柴胡汤证具、而以他药下之、柴胡证仍在者、复与柴胡汤、此虽已下之不为逆也①·必蒸蒸而振、却发热汗出而解、若心下满而硬痛者、此为结②·大陷胸汤主之、但满而不痛者、此为痞·柴胡不中与之、宜半夏泻心汤、（149）

注：

1. 《宋本》无“也”之。
2. “此为结”《宋本》作“此为结胸也”。

半夏半升① 黄芩 干姜 人参 甘草炙各三两 黄连一

两 大枣十二枚擘

注：《宋本》于“半夏半升”之后有一“洗”字。

右七味、以水一斗、煮取六升、去滓、再煮、取三升、温服一升、日三服、①

注：《宋本》此处有如下文字：“须大陷胸汤者，方用前第二法。”

胡希恕：那么这一段呢，伤寒五六日，这都是去表而内传的时候，起码传少阳的时候多了。呕而发热者，所以柴胡的这个使用啊，各方面都得多看。前边讲的这个，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，这是柴胡四证，四个主要的证候。他后来又说了，柴胡证但见一证便是，不必悉具，我们上面看的口不欲食也是一证，这个呕也是一证，发热不是柴胡汤的，柴胡汤是往来寒热，可是呕而发热，柴胡汤是个解热剂，那是柴胡汤证毫无问题，所以一证便是也得看全面的问题。那么我们对于柴胡汤的应用，在这些段落非得熟不可。假如我们在临床上只呕，它不是柴胡证，只是呕，小半夏汤证，内里有停饮，可以用小半夏，就是半夏生姜。那么呕而头痛，这类是吴茱萸证。呕而发热，是少阳病，少阳病是少阳热病，那是小柴胡汤证，这个地方非搞清楚不可。

那么这个与小柴胡汤就对了，但是与他药下之是误治，那么下之后病有的时候它变，那另当别论了。如果柴胡证仍在者，未因误下，辨证，而且还是有柴胡证，那还可与柴胡汤，那么虽然误下之后，这个治法也不为逆，也是对的。那么服之后呢，必蒸蒸而振，却发热汗出而解，这句话也不是说小柴胡汤是发汗剂。这个咱们讲了，蒸蒸而振，这个人啊先感觉蒸蒸发热，然后打颤振，就跟战汗的前驱症状差不多，先蒸蒸然发热后来颤栗恶寒叫蒸蒸而振，那么随后呢就出现大汗，这个病就解了。这说明什么呢？这是冥眩状态，那么他要是不吃泻药，开始呕而发热与小柴胡汤不会有这个情形的。那么由于泻后虚，人是正伤了，这个前面也说过，凡是久病或者是正虚较弱，那么这个

药再中病要发冥眩状态的。这个冥眩啊，当大夫的也得知道，要不然啊你就跑急诊室去了，那个非坏不可。我们遇到的病人啊已经吃了其他的泻药了，但是还是柴胡证，你就告诉他啊，你吃这个药啊是这个情形，要遇到这个你不要害怕，这就好了，那要是找救急去就坏了。只要是虚人，这个药要中病常常发生这种情况，古人还有这样一句话：“若药不冥眩，厥疾不廖”这是《尚书》上的话。那么这个地方非好不可，彻底好，这是好事不是坏事。但是病家和医家都得知道，这要是不知道，这还了得，冷成这个样子，还出一身大汗，这个坏了，这是头一段。

第二段呢也相当重要。第二段他说的大陷胸汤证，半夏泻心汤证和柴胡汤证的一个鉴别法。若心下满而硬痛者，心下就是指的胃，硬痛就是我们前面讲的那个热结于里，不但硬，而且疼，这个就是大陷胸汤证。但满而不痛者，心下这个部位，只是满，硬满，但是不疼，这是半夏泻心汤证，这是痞。这个为什么也叫痞？这个半夏泻心汤证本来是人参汤证，心下痞硬。可是里面也有黄芩、黄连，就这个方药咱们来分析，也有邪热内陷的这么一点，也有黄芩、黄连嘛，所以也管它叫做痞，也叫泻心汤，其实它的这个心下痞硬泻心汤证，是胃虚邪凑的这么一种病，后面有解释啊，现在我先这么说。

那么这个柴胡剂啊，它是胁满，两侧，不是心下。这个心下满也有胁，牵引到心下，它必胁满，所以它才说柴胡不中与之，这一句话就说三个方剂的鉴别点嘛。一个心下满硬痛，这是大陷胸汤证。只是心下满而不痛，这是半夏泻心汤证。若是胸胁满，是小柴胡汤证。它主要是三个，看起来是两个，其实含义是三个，柴胡不中与之，这一句话就包括了。我们看看这个半夏泻心汤，半夏、黄芩、人参、干姜、甘草、黄连、大枣。它这个人参，这个药啊，我们现在有些人老想吃参，它不是个万灵的药，人虚，它是补虚。这个药也有它的证候，这个人参补虚啊，它在于胃虚，而且现心下痞硬的这种情况才能用，这

是根据张仲景的这个书，我们平时用它呢，也是健胃，如果胃实，那没有用人参的，那不是一个好药，那是有害无益。咱们说它补气，也有道理，这个气就是津液啊，它是来自于水谷，化生于胃，你胃要不好，这个就是津液不行而气虚啊，那个气就是指的津液说的，咱们上边说的手足冷就是的，手足冷，胃不行津液，津液不达于四末就冷，那么这个方剂它用人参健胃而去心下硬，它主要是硬，心下痞硬，那么它也有邪啊，不是没有邪啊，胃虚客邪之气都往胃上去，所以它用黄芩、黄连以去热邪，这个也叫心下痞硬。那么半夏、干姜，我们看《金匱要略》有半夏干姜散啦，它止呕。那么人参与甘草大枣合着都是健胃安中的药，都是甜药。所以这个方子又能治呕，有半夏、干姜，有人参、黄芩、黄连也能治心下痞硬，它非心下痞硬不可，只是心下痞不行。那么半夏和干姜都是辛味，干姜更温，都是去水的，不光有热，同时有胃虚，同时这个水也往上凑，胃中有停饮，所以这个方剂啊，里头有渗水声，肚子里面瓜拉瓜拉叫唤，另外它还有腹中雷鸣，大便溏泄，这个方子全治的。那么在这儿呢它只是提一个心下满，这不是全证。全证：呕而心下痞硬，腹鸣，它必有这些证候，或者下利，它下利也治，那么这个方剂也是常用的方剂。我们现在对于胃肠功能紊乱，用现在的话说，这个方剂都常用的，又有呕，大便又溏泄，肚子瓜拉瓜拉叫唤，心口这个地方觉堵塞，不愿意吃东西，这个方剂都常用。

李冠杰：这个条文也是一个顶格的条文。

旁注“此虽已下之不为逆也”，到了《宋本》没有这个“也”字。另外旁注的“此为结”，《宋本》是“此为结胸也”。

下边我们解读一下：

“伤寒五六日、呕而发热者、柴胡汤证具”，就是患太阳伤寒，病程比较长了，由于人体的抵抗力逐渐降低，到了五六天的时间发生了“呕而发热”，这个“呕而发热”是典型的柴胡汤证，可以确定是

柴胡汤证了。但是我们应该客观地来看，“呕而发热”也仅仅是一个症状反应，还可能会存在其他的，那个都没关系，只要是具备了少阳病的典型症状，就可以认为“柴胡汤证具”了。为什么要做这么一个解释哪？在这本书的第 379 条是“呕而发热者，小柴胡汤主之”。但是这个条文是降一字格排版的条文，实际上这个条文就是从这个地方通过解读以后摘出来的，就把它单独了。这叫什么？说得好听，这是强调小柴胡汤证有时会以“呕而发热”的形式表现出来；说得不好听，这叫断章取义。从这个地方摘出来以后放到那个地方去了，就是这个作者认为原文里边有这样的论述，我们就可以确认，凡是“呕而发热者”，就是小柴胡汤主之。但实际上，“呕而发热”不仅仅是小柴胡汤证，大柴胡汤证也可能出现“呕而发热”。大柴胡汤证就有，呕不止，大柴胡汤证出现发热的，在临床当中也不是一例两例。

我就曾经碰到这么一个女孩子，平时她也不爱吃饭，有时候也会有呕的感觉，但不特别明显，刷牙的时候有些干呕。医院里边诊断是无名低热，体温常在 38 度左右，烧的浑身都没有劲，也不能上班，持续了一个多月的时间。在这其间输了几次液都不管用，看过其他中医也不管用。我给她看了看，她就是一个大柴胡汤证，然后我就给她大柴胡汤，七天的药，结果就吃了两天就好了。

“而以他药下之”，少阳病既不可汗也不可下。无论你使用哪一种泻下的方剂，都是误治。这个条文论述的是因为误下了以后，致人有了里虚，但是他仍然保持在少阳病病理阶段这个情况。

“柴胡证仍在者，复与柴胡汤”。虽然误下了，但是疾病的性质并没有变化，病人仍然表现为柴胡证，所以说还得用柴胡剂来治疗，“复与柴胡汤”。这个地方明确了经方的一个治疗原则，而且还是一个很重要的治疗原则，不管病因如何，也不管经过了什么样的误治，“有是证，用是方”。这个地方论述的就是这样的。经过了误下了以后，还有柴胡证，就还得要用柴胡汤来治疗。

但是像这种情况，通过临床实践发现可能会出现一些暝眩反应“必蒸蒸而振，发热汗出而解”。这儿的“必”字，应该当作“可能”来理解。如果理解成必然，必定，那完全是不一定的。以前是表证，下了以后表证也好了，也没有发生少阳病的，还有这种情况呢。以前有少阳病，经过泻下以后，必然还是少阳病的那些反应，这也不一定，只能说出现这种反应的可能性比较大。“蒸蒸而振”就是战汗的一个过程，一个反应。发热恶寒特别重，打寒战，最后出了汗以后病就好了，这种情况在临床当中还是常见的。为什么会出现这种情况呢？就是因为用“他药下之”，下了以后致人虚。如果碰到偏于虚的病人，你得有这方面的思想准备，有必要的話，你也可以告诉病人的家属，特别是小孩子，告诉他的家长。如果一旦孩子出现发烧啊，那他这个病一定能好，你不要害怕。这是一种玄冥反应。

旁注：“此虽已下之不为逆也”，应该理解成虽然经过了误下的治疗，但是没有发展为其他类型的疾病，“不为逆”是古人的一种说法。要是从字面上看这个“下”也不错嘛，不是这个意思。就是说没有出现其他类型的疾病，疾病没发生质的变化。

这个条文的下面又列举了少阳病误下以后，容易出现的两种变证，一个是：下了以后，可能出现“心下满而硬痛者”，就得用大陷胸汤来治疗。这儿“心下满而硬痛者”，是一个简文，因为关于大陷胸汤证其他的症状反应，在其他条文里面都做了比较详细的论述。这个地方重点说的是少阳病误下了以后，有可能出现大陷胸汤证。是不是大陷胸汤证？而要进一步地辨证。大陷胸汤证，不会单独的就这一个证，必然会有里实热证，必然会有有的。

“但满而不痛者，柴胡不中与之，宜半夏泻心汤”。这个地方有一个“不中与之”，“不中”就是“不可”。“但满而不痛者”，这个“但”字，有两方面的含义：其一是衔接上面，上文有“心下满而硬痛者”，这个“满而不痛”的部位应该也是在“心下”，这是其一；

第二这个地方的本意呀，应该理解成“只是”或者“仅仅”，只是“满”但是没有“硬痛”这么一类的症状。“柴胡不中与之”，因为柴胡证有一个典型的症状是“胸胁苦满”，以胸胁部位的满而感觉不舒服，满到都感觉到痛苦。这个地方是“心下”满，跟“胸胁”，一个在中间，一个在两侧，往往在临床当中辨证容易搞混了，这个地方再强调一下。虽然有“满”的感觉，但是这不是柴胡证。另外这个“但满而不痛者”也是一个简述。实际上半夏泻心汤证还有好多其他的症状反应，他只是拿出来一个比较常见，而且容易和柴胡证弄混了的这么一个症状“满而不痛”，来作论述。实际在临床当中，半夏泻心汤证“呕而肠鸣”，“下利”，还有好多其他的症状。

下面做一个小结：

患伤寒病五六天的时间，出现呕而发热的，即可确定为柴胡汤证，但是医者却以泻下的方剂给予治疗，如果泻下后柴胡证仍在的，可再用柴胡汤治疗，虽已经过误治，仍属于正确的治疗方法。但是服药后可能出现蒸蒸而振并发热汗出之后，疾病方可解除。如果泻下后出现心下满而硬痛的，为大陷胸汤主治之证。如果只是心下满而不痛的，也不可用柴胡汤治疗，适宜用半夏泻心汤治疗。

下面我们看看“半夏泻心汤”，在整个这本书里边，这儿还是主要论述它的地方。半夏泻心汤由7味药组成：半夏、黄芩、干姜、人参、甘草、黄连、大枣。在《康平本》和《宋本》之间有一点小区别，一个是半夏后边在《宋本》里边有一个“洗”字，《康平本》里边没有，恐怕是漏了。在《宋本》这个方后注之后，有一个“需大陷胸汤者方用前第二法”这么十二个字，在《康平本》和《注解伤寒论》里边都没有，恐怕这就可以算作一个悬文了，没有用。

我们看看这个方剂，半夏、干姜、人参、甘草这些药放在一块，温中健胃补虚。这四味药可以视为“理中汤”去了白术加半夏。白术和半夏都有去饮的功能，但是半夏的止呕是白术没有的。这四味药放

在一起的话，不单单有理中汤的功能，同时还有止呕的作用，比理中汤恐怕还要好一点，就是强调了这方面的功能。如果把这四味药看作一个方剂的话，这里边还包括了什么？半夏干姜汤和干姜人参半夏丸，这都是温中健胃止呕的方剂。黄芩、黄连，既可以去半表半里之热，又有止利的功能。只要是符合这个方证，如果大便不好的，它可以治。

半夏泻心汤证病理，就是里虚寒证兼半表半里的热证。

半夏泻心汤在临床当中也是一个常用的方剂。有一个病人呢，也没有什么明显的诱因突然出现上吐下泻，我问了问，他说大便里边带有不消化的食物，也没有其他的明显的症状，但是病来得很急。我就给他理中汤，理中汤吃下去以后，上吐下泻就好了。从第三天开始，食欲开始好转，但是大便一天两三次还有点偏溏，又来我这二，他说是不是还接着吃那个药，他说肚子里边老咕噜。我说好，那个药你先别吃，我就给他半夏泻心汤，摸他的脉有点滑象，舌质有点偏红，他多少有一点热象，他吃了就好了。半夏泻心汤治肠鸣腹泻，胃肠不好的，就是说捷效。

半夏泻心汤证症状：胃脘痞满、纳呆、呕吐、腹泻、神疲乏力、胃脘痛、肠鸣。肠鸣在半夏泻心汤证里是一个很典型的症状。凡是肠鸣再伴有腹泻，吃饭不好，胃肠不好的诸多胃肠疾病的话，都是半夏泻心汤证。

舌质：红舌、淡红、暗舌、淡胖有齿痕、边有瘀斑的。

舌苔：黄腻、白腻、薄黄、薄腻、白苔。

脉象：弦滑、弦细、弦数、弦、沉细、细弱。

现代疾病：急性胃炎、慢性胃炎、浅表性胃炎、萎缩性胃炎、糜烂性胃炎、胆汁反流性胃炎、疣状胃炎、胃下垂、胃扩张、胃肠神经官能症、肠淤积综合症、十二指肠炎、十二指肠溃疡、胃溃疡、消化不良、胃窦部溃疡、胃角部溃疡、胃大弯溃疡、胃小弯溃疡、上消化

道出血、消化系统溃疡性大出血、贲门痉挛、急性肠炎、慢性痢疾、菌痢、慢性结肠炎、小儿腹泻、小儿消化不良、胃功能失调、便秘、胃扭转、胆囊炎、慢性肝炎、早期肝硬化、消化道肿瘤、胰头肿瘤、急性食道炎、食道癌、胆囊癌至肝转移、贲门癌、幽门梗阻、食道中段癌术后综合征、病毒性肝炎、慢性活动性肝炎、转氨酶持续异常、胃粘膜脱垂多涎症、假性胰腺囊肿、慢性胰腺炎、肾病综合征、肾功能衰竭、慢性肾炎尿毒症、肾炎尿毒症尿猝性肠炎、慢性肾炎后期、尿路感染、高血压、心肌炎、病毒性心肌炎、心力衰竭、心律失常、风心病心衰、心房纤颤、妊娠恶阻、子烦、子渴这些东西有点是中医的病名啊，妊娠泄泻、妊娠呃逆、行经口腻、不孕症、闭经、带下、慢性支气管炎、失眠、头痛、梅核气、阳痿、早泄、遗精、过敏性鼻炎、口腔溃疡、美尼尔氏综合征、顽固性智齿、手术后顽固性呕吐、湿疹、带状疱疹、嗜酸性细胞增多症、肝血卟啉病、小舞蹈病、午（子）时夜汗、神经失调、胃肠型感冒、黄疸、耳鸣，这个病太多啦。

这说明什么呀？说明这么多的疾病都有可能是在“半夏泻心汤证”的病理状态下发生的。这里边呀，有个肝炎，肝炎有可能是在半夏泻心汤证的病理状态下得的。如果是在这种病理状态下得的话，用其他的方剂来治，就治不好。

大阳少阳并病、而反下之、成结胸、心下硬、下利不止、水浆不下、其人心烦、□□□□□^①、（150）

注：《宋本》无此五个缺字符号。

胡希恕：太阳病不可下，少阳病也不可下，我们讲到少阳篇就更清楚了，这个大夫啊，而反下之，大夫无知啊，而吃下药。那么这个太阳少阳，这都是个热病，都是热啊，阳性病啊。它一下虚其里，这个表邪外邪，外邪指的是少阳的邪，在卫外。表邪也就是太阳之邪，

在体表。趁卫气之虚都陷于里，那非成结胸不可，所以成结胸而心下硬。这个结胸心下硬，不光硬它必疼啊，因为前面有解释，……不但邪热结于上而为结胸，同时邪热也陷于下而下利不止。那么上文所解，所以水浆不下啊，其人心烦，烦躁不安，那么这个病呢是个厉害的病，看它样子。所以仲景也没出方，那么也就是说，太阳少阳并病更不能吃泻药，泻药能够造成危笃重症，这病不好治。这个结胸证非攻不可，下利不止你用什么攻，所以这个治病怕这样的，攻补都是两难措手，一治下利吧，上边堵着呢，结着呢，也没好法，所以他也没出方，而且人又心烦不已，这都是一个不好的现象，所以这是一个危笃重证，难治！所以他也没出方。这就警戒人了，那么这个病不要随便吃泻药啊。

李冠杰：“太阳少阳并病，而反下之，成结胸，心下硬，下利不止，水浆不下，其人心烦”。在《康平本》里边，到这儿并没有结束，后边有五个缺字符号。

下边，解读一下：

“太阳少阳并病、而反下之”，强调这是个误治。并且误治会产生一些后果，“成结胸”。这也是一个简单的定性的一种说法，是对后边出现的这些症状做的一个病理解释，出现了结胸证。那么具体的症状反应呢？“心下硬、下利不止、水浆不下、其人心烦”。“心下硬”这个症状这是典型的，这个地方是简文了，应该是“心下满硬痛”才比较准确。这就说了“心下硬”，也暗示着跟大陷胸汤证有一定的区别。

“下利不止”，在大陷胸汤证里边是没有的。换句话说，虽然也是结胸，但是跟大陷胸汤证不一样，这个有下利。这样呢，就超出了大陷胸汤治疗的范畴。大家看一看，大陷胸汤有大黄、芒硝。如果这个人再下利的话，用这类的药那肯定是不行的。这个“下利不止”，是这个条文所论述的一个重点，因为跟大陷胸汤证不一样了，就不能

用大陷胸汤治了，这是肯定的。那么“下利不止”说明什么？说明人体至少是一种虚证，起码没有实证，他有下利嘛。在这个条文论述里边，前边有一个“下”的过程，这个地方是“下利不止”，等于说这是一个虚证。这里论述的是一个虚证的情况。

“水浆不下”，误下以后虚其里，胃气将近衰败了，吃了东西以后胃里受不了，虚不受食了。

“其人心烦”，这个人既有结胸证，又有胃气衰败的这种情况，在这种情况下出现心烦，不像一般的柴胡证的那种心烦，而是一个重症的“躁扰不安”之类的，有那样的苗头，所以这个“心烦”是个重症。

这个条文论述的就是太阳与少阳并病的情况下，误施了下法以后，出现的一种水与热结于胸胁，同时又有“下利不止”，胃气又衰败的一种重症，论述的就是这么一种情况。

那么用什么方法来治呢？就关于上边这些理解，历史上众多的注家，认识基本上都是一致的，其中读得精的人还是有，其中有一个喻嘉言，喻嘉言就曾经说过这样的话，“‘其人心烦’似不了之语”。人家体悟到这个事了，他感觉到这个条文不太完整。那么这样呢，随之就出现了一个不可回避的问题，就是说这个条文原来就是一个残缺的条文，咱们看到的《康平本》就是《伤寒论》我们现在能见到的最早的版本。这个版本明确地告诉我们这是个残缺的版本，在“其人心烦”之后，或者有治疗方法，或者有其他的论述，或者说有其他的内容。缺了这五个字，假设说是，“某某方主之”，或者“可与某某方”，或者“以某某方”的话，那么丢失的这些内容就相当重要了。

通过这个条文学习，我们大家是不是有这种感觉，你只有参照《康平本》之后，才能知晓还有这一类的问题存在，从中可以启示我们去探寻一下具体的治疗方法应该是什么？如果单纯地去学《宋本》，或者其他的版本的话，这一块儿信息我们就知道了。

脉浮而紧、复下之^①、紧反入里、则作痞、按之自濡、但气痞耳、（151）

注：“复下之”《宋本》作“而复下之”。

胡希恕：脉浮而紧，这是邪在表了，这是太阳伤寒脉，那么这依法当发汗，而反下之，这也是大夫误治，紧反入里，这个紧啊当邪字看，紧反入里没法讲啊，就这个邪反乘下后之虚而陷于里，那么所以它变成痞，痞又是指心下痞呀，这个结胸，甚者是结胸，那么轻者为痞，这个病不在阴在阳，那么开始的时候病发于阳，下之则成结胸，病发于阴，下之则成痞，那个痞是痞块的痞，与这个不一样，这个慢慢地弄明白，后头还有。那么这个心下痞满，这个否它是卦名，天地否嘛，这个卦爻啊，所谓地气为上升，天气为下降，所以地天泰，这个地在上，就是这个坤和乾，这是一个地天泰。地气在上头，天气在底下，那么也就是说天气得下交，地气得上升，地气上升为云，天气下交为雨，这个万物才能繁荣，所以这叫天地泰。那么如果天不下降，地也不上升，这叫天地否，乾坤，上头是乾卦底是坤，那就坏了，那就是否塞不通了。那么这个书上啊，古人是借用了，这个痞是怎么回事呢？就是上下不通，它有这个，痞满，但是这个痞不是痞块，按之自濡，拿手按它呀，不抵抗，没有抵抗力，所以但气痞，耳，只是。这个气呀，也要活看，不是那里头有气，古人凡是无形体的东西都叫气，明白了吧，咱们说这个天气热，这也是气，比如说人有勇气，这勇气是什么？就是无形体的东西，它可以有一定的作用，这古人都叫做气。那电气也是，电气这都是气。所以这个气痞呀，不是这里面存住气了，那么讲也错了，就是没有实质的东西。那么现在指什么呢？还是有炎症总而言之还是有炎症，他就用泻心汤嘛。

李冠杰：这在《康平本》里为降一字格的条文。《康平本》里这

个“复下之”在《宋本》是“而复下之”，多了一个“而”字，没有太大的问题。

我们解读一下：

“脉浮而紧”，明显的就是指的太阳表实证而言的。整个条文里关于误下之前的论述，就这么一个脉象。可见条文的作者比较重视脉诊。再看看其它条文，比如第140条中降一字格排版的那部分内容，跟这个应该是一个作者，学术观点上都比较类同。从这一点上也能看出《康平本》的真实性。

“复下之”，太阳病用下法，这肯定就是误治了。

“紧反入里”，应该理解为原来脉是浮紧的，浮而紧，但是下了之后，原来浮紧的脉变得相对的沉紧，有点沉了。这是用脉象的变化来论述整体疾病因为误下以后发生的变化，他意思就是想说明由表证进而发展为里证，沉为在里嘛。

“则作痞”，也就是太阳病误下以后，如果浮紧的脉变为沉而紧的脉，就有可能发生痞证。

这个痞证具体什么样的呢？这个地方对临床指导是比较现实。

“按之自濡，但气痞耳”，这是一个具体的诊断的方法，做个腹诊，用手摁一摁里面比较柔软，没有抵抗感。像这类情况的患者比较喜按，就是摁着他没有明显的不舒服，没有或疼、或满的情况。这种情况应该说是一种虚证，这儿的“气痞”的“气”不是指气体的气，这儿的“气”应该把它理解成“功能”的意思。这就是说因为误下造成里虚，而形成感觉心下痞塞不通的一种主观感觉，这是由于虚造成的。

做个小结：太阳表实证，医者反以泻下的方法治疗，致里虚而发生痞证，按胃部则较为柔软，此属于里虚所造成的气痞。

大阳中风、下利呕逆、（注）表解者·乃可攻之·（经）其人桡

赧汗出、发作有时、头痛、心下痞硬满、引胁下痛，干呕短气、汗出不恶寒者、此表解里未和也·十枣汤主之、（152）

芫花熬 甘遂 大戟

右三味等分、各别捣为散、以水一升半、先煮大枣肥者十枚、取八合、去滓、内药末、（注）强人服一钱匕·羸人者①服半钱·（经）温服之、平旦服·若下少、病不除者、明日更服、加半钱·得快下利后、糜粥自养、

注：《宋本》无“者”字。

胡希恕：这段可不好讲了，一般注家都搞错了，他这个病呀，开始太阳中风，下利呕逆，这说的什么呢？这说的葛根汤，葛根加半夏汤。翻到 32 条葛根汤都知道了。太阳阳明合病，必下利，若呕者，加半夏汤主之。他怎么搁个太阳中风呢？这就是古人以方药立证，就给证归一个立字而已，你看葛根汤这个药，他是桂枝汤为基础，桂枝汤加麻黄、葛根，这么一个药，桂枝汤治中风啊，所以古人也叫中风，他和大青龙汤一样，大青龙汤也有桂枝的关系，那个都包括桂枝去芍药汤，他也叫太阳中风，可是他没有中风证候，脉紧身疼痛，不汗出而烦躁，葛根汤也是，你看葛根汤恶风两个字，古人的意思中风就怕风啦？其实这是存在问题的，但我们这一点要知道，在临床上，葛根汤这个药啊，他恶寒甚都恶风，大青龙汤也是，所以我们在临床上遇到表证啊，恶寒特别厉害，同时发烧，这个不是葛根汤证就是大青龙汤证，这两个方剂也好辨别了，葛根汤证是项背强几几厉害，大青龙汤证是烦躁的厉害，他得有热，热比较突出，这得思考，大量的思考，那么古人说中风也有道理，他是有这个桂枝证气上冲的厉害，葛根汤就是由于气上冲啊，体液不向下走，处于上边所以项背特别强，这个项背强达到高度就要抽了，就因为气上冲的关系，所以就用桂枝，由于这个证候里包含着桂枝证，所以古人管葛根汤叫太阳中风，那么这

个病应该是这样的，你们看下葛根汤，应该是太阳中风，头痛发热恶寒这个病，同时呢有下利或呕逆，这是说表证这一方面，同时还有下边这些东西，心下痞硬满，引胁下痛，心下痞硬满引胁下痛啊，在《金匮要略》里头是指悬饮了，这个饮积于胁谓之悬，胁的一侧，我们现在严重的心膜炎哪等等，类似这类的病，这个悬饮须攻，但是他有葛根加半夏汤证，这个头痛发热恶寒，脉浮又呕吐又下利，同时有这个心下痞硬满引胁下痛这个悬饮内痛的证候，这个应该先解表，所以说表解者乃可攻之，乃可攻之指的下边说的，并不是指下利呕逆，下利呕逆用十枣汤那可不行你看这篇文章，错语的厉害，很不好懂，他本来是十枣汤证，同时又有葛根加半夏汤证。所以太阳中风下利呕逆，这是葛根加半夏汤证。那么必须表解乃可攻之，表解用什么，就用葛根，葛根加半夏。所以底下这一套，都是吃完这个药之后啦，其人𦛮𦛮汗出，发作有时，头痛，这十枣汤也有头痛啊，心下痞硬满，引胁下痛，那这个时候他不是下利呕逆啦，是干呕短气，没有下利呕逆了，是吃过葛根加半夏汤，下利呕逆随着表证全解了，只是干呕短气，他为什么感到短气？有水饮在里头啊，要短气没有水饮他也干呕但是他不象下利呕逆那个样子，所以底下说汗出不恶寒，可见以前是恶寒，由于𦛮𦛮汗出他就不恶寒了那么这个时候，他底下说表解里未和，这是表没有了，只是里未和呀，十枣汤主之。有很多注家都这么给讲的，说有发烧怕冷，要吃解表的药，表解了，又有下利呕逆，这都搁里头了，就用十枣汤。这个用十枣汤的药相当厉害呀，泻下相当凶，下利呕逆能吃这个药吗？没有这个事儿。这一段你们看看注家那本可以参考一下。这个匀两头看，一个是发汗以前，吃葛根加半夏以前，他有下利呕逆头痛，发热恶寒，心下痞硬满引胁下痛，那么经过服葛根加半夏之后，没有下利呕逆，发热恶寒，这都没有了，只是头痛，心下痞硬满，引胁下痛，干呕短气，这是吃完葛根加半夏的证候了，根据这个来说，这是表解里未和也，应该用十枣汤。那么这三个药啊，芫

花、甘遂、大戟，这都是下水的毒药，这都有毒，所以用量都特别的轻，泻下相当的重，我们看看方后注的说法。上三味等分，各别捣为散，以水一升半，先煮大枣肥者十枚，取八合，去滓，内药末，强人服一钱匕，就是壮实的人可以给到一钱匕，这个匕是古人盛药的器皿，就像现在小勺似的，古人的一钱就是现在的三分了，强人吃这些，羸人服半钱，瘦弱的人吃半钱，半钱那很少了，一分半，温服之，平旦服。若下少，病不除者，泻的少而病还不去，明日更服，一天不要连续吃这个药，这个毒药，但他也毒不死人哪，加半钱。明天吃的药量稍稍加一点，吃一钱的吃一钱半，吃半钱的增加到一钱，得快下利后，糜粥自养。快下利，这个药我用过，下利非常的凶，这时候停药，糜粥自养，这么凶的药能治呕吐下利吗？不能。这三个药啊，芫花、甘遂、大戟这三个药差不多，都是下水的药，那么搁上大枣，这个妙不可言，大枣这个药，古人方子中用猛峻的药都用甘药调和，都用甜药，甜能补脾呀，就是安胃，你不顾正不行啊，胃不都给治坏了吗，所以胃不能给治坏，他为什么不要甘草而用大枣啊，大枣这个药，甜药之中能利小便，能去水，既能顾正而制这个毒药，同时也能去水，可是这个枣得多用，药只是用几分（按现在说），就搁上十个肥大枣，药如果多用大枣也得多用，所以这个方子我常用，他不但治悬饮这类病，凡是胸水都能治，甚至有时也用来治腹水，真正的实证的腹水也可以用，但不要这么用，我用这个大枣最少用半斤，有时我用一斤，这大枣先煮，煮得没魂似的，把皮和核挑出来不要，只是汤和枣肉都在里头，我用汤剂不用这个粉剂，这几个药芫花、甘遂、大戟，我都用二钱到三钱，用的好象挺重的，其实没多大关系，你要这么大量的枣，把这么几味药搁到枣汤里煮，要大砂锅，要一斤得用大砂锅，搁里头煮，煮一个差不多，把药捞出来，就喝这个枣汤，吃枣肉，让他少吃，一下子吃多了那得泻的不得了，一会吃一点儿，稍稍的下了，那就暂停，我这么治好很多人，尤其胸水，相当保险，你们可以这么用，心

里没底搁二钱也行啊，不过这枣必须得搁，没枣可不行，我就根据这个来用这个汤剂的，在胸水、腹水我都用，但是必须得加小心，所以古人在这上头是特殊注意的。

李冠杰：这是个顶格的条文。

咱们解读一下：

《宋本》将注解文字篡为正文以后，给解读带来了一定的误导。“表解者乃可攻之”，是嵌注，它不是正文。如果把嵌注内容剔除出去，正文成了：“太阳中风，下利呕逆，其人𦹑𦹑汗出”。咱大家仔细的再品，细品这个地方，“其人𦹑𦹑汗出”之前，“下利呕逆”之后，应该还有其它的内容。按着经方的论述跟这一条文它造成的后边的这些方证、这些症状反应，这个地方很可能有一个类似于“下之”之类的，总之是用了一个泻下的方法。单纯从字面上看，如果只是论述的太阳中风的兼证，如果这个地方没有内容的话，大家看啊，这个条文的内容就等于说是，“太阳中风”，同时又出现了“下利呕逆，𦹑𦹑汗出”。“发作有时”等下边的这些啊，都是在太阳中风的前提下又出现了这么多的症状，但是这里边既然都是太阳中风的兼证的话，“其人”这两个字就没有必要了。假设中间有“下之”两个字的话，这个“其人”就显得非常恰当，这是从这个字面上这么看。另外原文的后边还有一个“干呕”呢，这个症状和那个呕逆不是相似的症状吗？终归重复的出现，它让人感觉也不像这个经方的论述风格，但是这个条文确实确实有重复论述的啊。这个地方应该是误下的一个过程。

“太阳中风，下利呕逆”，这个地方就比较好理解了，太阳中风证有时就可能出现下利或者说呕逆这样的症状，这也属于它的症状反应之一。在第12条里边有个“鼻鸣干呕”，“干呕”不就是呕逆的意思嘛。在第276条里边呢，把桂枝汤说成是太阴病，太阴病脉浮的可以发汗，指的是什么？实际上在临床统计资料里边也有，桂枝汤证

有时候会出现下利。它要表现为下利，表现为桂枝汤证的时候，用桂枝汤治疗就可以了，表现为葛根汤的表实证的时候就是葛根汤证。既然下利和呕逆本身就是太阳中风证的这个症状反应，我们可不可以把它叫做或然证，是可能出现的症状之一。为什么这个地方强调它？强调它就是在强调这个人本身就是不单单有太阳中风证，而且有里虚的情况，属于太阳中风证兼有里虚的这种情况，里虚比较明显的。接下来是嵌注内容，这个嵌注注解得也非常有意思，“表解者乃可攻之”。这里出来一个问题，后世的注家啊，因为他们看到是《宋本》啊，《宋本》里边这都是正文，有人对这个“表解者乃可攻之”就提出异议来，说他得的这么重的病，一个是有可能还存在表证，另一个，像这么重的病你再让他吃解表药没有道理，因为有里虚存在。那么他为什么要加这个嵌注的内容？这个地方很可能当时这个作者拿到的这个原文啊，这个地方就是有缺字，看不太清，他也感觉这个地方可能是一个下法。他感觉按照经方其它的地方说的，你要想攻的话，有表证得先解表，然后他就做了这么一个注解。但是整体来看的话，当我们现在知道它是注解内容的时候，这个注解加得并不是太好。因为就是下了以后，实际没有表证。看后面的症状反应就知道了，其人“漐漐汗出”，它的原意是小雨绵绵不断的那个意思，在这里来形容人的汗出也不大，但是老是在出。

“发作有时”，这个太阳中风证本来它就有这个汗出，经过误治以后人虚了，仍然有一些微汗出，但是表现为发作有时，这等于说它是有了半表半里证的特征，这个汗出也不是典型的表虚证的汗出了。

“头疼”，这个头疼在这个地方如果是单独的看呢有点像是表证，但是实际上十枣汤证也可能出现，结胸证也可能出现头疼的。

“心下痞硬满”，就是因为误治了以后，发生结胸证的症状反应，这个非常典型了，跟前面论述呢都是一样的。

但这个地方又多了一个症状，就是“引胁下痛”，这个“引胁下

痛”应该是十枣汤证区别于大小陷胸汤证的一个比较有特征性的症状反应。但是实际在临床当中，有时候也不仅仅是“引胁下痛”，像这个因为结胸证常伴有咳嗽、喘哪，有时候咳嗽的时候有胸痛，这种情况也比较普遍。

“干呕短气”，这是水和热结了以后，对胃功能产生的影响。这个“干呕”呢前边本身就有呕逆，应是出现了结胸证以后，这种症状又遗留下来，但遗留下来以后，很有可能就已经不是表证的因素造成的。

“汗出不恶寒”，特别是这个“不恶寒”，前边呢有一个蒸蒸汗出，这呢又出现了一个汗出。但这个“汗出”明显的是为“不恶寒”作衬托了，就是说虽然有汗出但是不恶寒。说明它不是表虚证了，同时又说明人体啊有了一定程度里热证。

这个条文它论述的实际就是表虚证，这表虚证已经非常轻微，或者基本上没有表证了，出现了里虚证。一开始的时候是太阳表虚证又偏于里虚的病人，误治了以后发生了既有里热又没有里实，仍然有里虚，同时又出现了结胸证的这一种情况，那么这种情况呢，就得就需要“十枣汤”来治疗。

我们下边看“十枣汤”，一共四味药，芫花、甘遂、大戟这三味药是主药，另外一味药在方后注里边是大枣，它用的是十枚。这三味主药啊都有一个共同的特点，都是下水的功能比较强的药。而且这三味药放到一块，去水的功能就很强了。大陷胸汤为什么不用这三味药？这三味药去水的能力很强，但都有毒，能少用就少用。大陷胸汤有芒硝、有大黄，芒硝大黄跟着什么就下什么，下热、下实，同时有甘遂在，下水的力量就已经很大了，所以没有用芫花和大戟。但是这个地方有里虚，而且还有水结，得把这个水去掉，那么怎么办呢？就加强了去水的药。可是去水的药加多了里边毒性就大了，都有毒这三味药。其它的像什么茯苓啊、白术啊那类的药解决不了这问题，就非

得这种药。毒性增大了用了什么办法？用了大枣。大枣即能补里虚、又能缓解这个药的毒性，同时大枣本身也能下水。你看这古人这组方，就非常精妙。关于这个方剂的用法呢，胡老论述的非常详细，咱们这就不做过多的解释了。

下面呢咱们看看在“十枣汤证”这种病理状态下，能够出现什么样的症状反应？

症状：胸痛、腹胀大、呼吸急、不能卧、纳呆、浮肿、尿少，这些都是比较典型的症状反应。

脉象：弦、沉、滑、有力、实、紧、大、浮、细、弱、小。

舌质：淡、红、紫红、暗红、瘀斑、胖大。

舌苔：白腻、薄白、滑、薄黄、黄白。

现代疾病：渗出性胸膜炎、结核性渗出性胸膜炎、胸腔积液、肺癌、腹腔积液、肝硬化腹水、急性肾炎、急慢性肾炎水肿、肾小球肾炎水肿、肾病综合征、尿毒症、心源性水肿、类风湿、神经分裂、自发性气胸、腹膜炎、红斑狼疮、晚期吸血虫病、小儿耐药菌肺炎、顽固性便秘、慢性肥厚性胃炎、良性颅内压增高症。

大阳病、医发汗、遂发热恶寒、因复下之、心下痞、（注）
表里但虚①·无阳则阴独·阴阳气并竭·（经）复加烧针、因胸烦、（注）
面色青黄、肤瞤者难治、今色微黄、手足温者易愈、（153）（经）心下痞、按之濡、其脉浮者、关上·大黄黄连泻心汤主之、（154）心下痞、而

复恶寒、汗出者、附子泻心汤主之、（155）②心下痞、与泻心汤、痞不解、其人渴而口燥者③、小便不利者、五苓散主之、

（注）一方云·忍之一日乃愈·（156）

注：

1. “表里但虚”《宋本》作“表里俱虚”。
2. 《宋本》“心下痞”之前有“本以下之，故”五字。
3. “口燥者”《宋本》作“口燥烦”。

大黄黄连泻心汤方①

大黄二两 黄连 黄芩各一两②

右三味、以麻沸汤二升渍之、须臾绞去滓、分温再服、

③

注：

1. 《宋本》无此方名。
2. 《宋本》方中无黄芩，其方如下：
大黄二两 黄连一两
3. 《宋本》此处有林亿等人所加按语如下：

臣亿等看详：大黄黄连泻心汤，诸本皆二味，又后附子泻心汤，用大黄、黄连、黄芩、附子，恐是前方中亦有黄芩，后但加附子也，故后云附子泻心汤。本云加附子也。

附子泻心汤方①

注：《宋本》无此方名。

大黄二两 黄连一两 黄芩一两 附子二枚炮去皮破别煮取汁

右四味、切三味、以麻沸汤二升渍之、须臾绞去滓、内附子汁、分温再服、

胡希恕：第 153 条：太阳病遂发热恶寒，这是一个褒贬之词，遂用的非常好，太阳病不是可以发汗嘛，发汗了，遂而到发热恶寒了，他说的是太阳中风证误用麻黄汤了，重剂发汗了，错了！随便吃发汗

药可不行，咱们在临床上也不断看到这些问题，太阳病本来发热恶寒，遂发热恶寒，更加重其发热恶寒了，这个头前也有，所以这个发汗啊，不合法，但伤其津液而表不解，大汗淋漓病必不除嘛。大夫一看发汗不行，又给吃泻药，这就瞎胡来了，这古人也是有一个中医的陋习，大汗过去不好了，吃泻药，这都不对，你得看他症状，（开始）发热恶寒，还发热恶寒，表还没解嘛，表还没解还当解表，但是必须用桂枝汤，如果正虚可以用新加汤啊，加芍药、生姜、人参，这都可以的，可是这个大夫又给吃泻药了。那么表邪内陷，心下痞。发汗虚其表，下之虚其里，所以他说表里俱虚呀，脉内营虚，脉外卫虚，就是卫气，所以阴阳气并竭，就是脉内、脉外的液体由于汗下失法丧失了，都虚竭了，无阳则阴独，古人以这个正气叫做阳，阴阳气并竭，古人总而言之叫做阳气。阳就指的精气，阴就指的邪气，这个也是，无阳则阴独，正气没了，而邪气独存叫阴。阴阳气并竭，下面又无阳则阴独，这话不成话呀？他这两个所指：头一个指的脉内、脉外其气俱竭，第二个指正虚竭而邪独在，是这么一个问题，这个地方要搞清楚。大夫一看不行了，人也虚下来了，他又加烧针，这烧针更不对头了，烧针也是发汗，他本来就津液亡失，这个邪独留，这个烧针热反不行，而再一次大汗，反伤其正，正益虚邪益盛，所以他才胸烦。这个胸烦谈的是心脏喽，阴阳气并竭，不足以养心，心烦而不安了。面色青黄，青黄，咱们说黄中搀杂铁青色了，那古人说是木来克土了，其实他就是光色无泽呀，黄而不润，暗中有青，这叫青黄。肤瞤就是肉跳，组织失去营养了，也是里头没有滋养的东西了，所以他跳，虚的相当厉害，难治，这也是个难治的病了。上面那个太阳少阳并病下之后，一方面心下硬，微结胸，一方面下利不止，也是个难治的病。难治就是不治！今色微黄，要是微微有点黄，尤其手心温者，卫气还在呀，手足温，也就是卫气还能达到四末，那竭也没有竭到那个份儿上，所以还可望之生，还能治好还能治。有很多疾病啊，古人有句话，“不药，

得中医”呀，有病了别吃药是从这来的，一吃药就容易药死，上面就是嘛。底下呢，就要讲心下痞了。

第 154 条：至于这个地方呀，有热，浮也主热，那么热结的浅，脉也浮，不沉，只是关脉稍稍浮有热，而结的不重，所以痞是常这个样子的，这里结在上面，心下痞按之濡，里面没有东西，所以胃也不虚，胃虚非痞硬不可，大黄黄连泻心汤主之，大黄配苦寒药可下热，所以叫泻心，心就是火，就是去火，下火的意思，大黄黄连二味药，但是量不重，大黄二两即六克，黄连一两即 3 克，以麻沸汤一升渍之，泡一下，须臾去滓，分二次温服，也有人说生大黄泻下不厉害，就看怎么用大黄，有时泻心汤比承气汤还凶，这都是不看药量及用法，少放大黄，则泻不会重，相等分量生大黄当然比熟大黄厉害。且煎生大黄比渍生大黄更有力，有效成分提出多故有力。渍是泡一下即可，我常用，我们用它不用绞去滓，就拿此方用开水泡一下就可以，少用点时间，把大黄取出，下次再用，这个不大泻，非要这样用，否则泻下重。如柯韵伯等认为此药下的了不得，心下痞按之濡，怎么能吃生大黄？其实不大泻。这个药非常的好，但是大黄黄连泻心汤用的机会不多，我都是用大黄黄连黄芩三黄剂，不只治心下痞，还治衄血，吐血都有效，尤其衄血，百发百中，小儿衄血，都用此种法子。

林忆等认为大黄黄连泻心汤就是三黄泻心汤，是从附子泻心汤推测的，我认为有道理，但是只给大黄黄连行不行，我认为也行。当然不如三黄泻心汤好，这个方子常用。所以大黄、芒硝等药，你配伍什么，就是什么作用，如前面的大陷胸汤，配甘遂下水的药，就下水，配苦寒的药就下火，配消食的药就消食，所以大黄橘皮汤，橘皮是一个消食的药，就是调胃承气汤给点陈皮也很好，配厚朴、枳实就消胀满，所以大黄、芒硝我们认为是一个驱毒药。

第 155 条：心下痞指上面的心下痞、按之濡，而复恶寒汗出者，这个恶寒，不是表证，是一个阳虚的样子，汗出是虚，与前头有“汗

漏不止”的情形一样的。这里没有表证，既心下痞，只恶寒而不是发热，而再汗出，这是虚衰的样子，所以用原来泻心汤解痞，加附子扶正，有人说附子是回阳，治阳虚，这也不免片面，附子能亢进机能的药，哪个机能沉衰都好用，所以小便失禁可用，心衰等可用，后面通脉四逆汤就看出来了，那是心衰厉害重用附子，故此药能振奋机能，单独说能回阳（机能沉衰都见于阴证）是不全面的。这里虽有心下痞，但机能沉衰，故外面一味恶寒，同时汗出不已，汗出用附子是因皮肤失其收摄，即脱汗，虚的特别厉害，故在泻心汤加附子，恶寒是正虚，正虚皮肤失去收摄而汗出，附子可振奋这些机能。

所以附子泻心汤证是泻心汤，而陷于阴虚的证候，这个阴虚是阴证的虚证，既是虚，且又为阴寒证的合称。

第 156 条：心下痞，也有水饮造成的，本以下之，心下痞，本来自于泻下之后而心下痞，用泻心汤是对的。但服后痞不解，那么此不是三黄泻心汤证，用此方就不行了。其渴而燥烦，同时小便不利，用五苓散才对的，就是水代谢机能差，主要是小便不利，饮多少水都不吸收，但组织缺乏营养，还是渴的厉害，所以渴而燥烦，所以我给人治病，我让人不禁口，病人缺什么，生理上就会想什么，想吃什么就吃什么。不想吃不要强求，否则非坏不可。肝病要营养，本来不能吃汤，非要吃汤，非坏不可，这里因小便不利，水不能被吸收，把废水一去，新水就吸收了，就好了。这里心下痞就是水在那里堵住了，要注意辨证。这一段可见，心下痞，泻心汤不是万能的药，得辨证，要是渴口燥烦，小便不利之心下痞，得用五苓散。

李冠杰：从《康平本》看，这是比较大的一个段落；但是在《宋本》里边给分成第 153 条、154 条、155 条、156 条这四条。

原文是这样的：“太阳病，医发汗，遂发热恶寒，因复下之，心下痞”；下边是一个嵌注：“表里但虚，阴阳气并竭”；给这个嵌注呢，后人又做了一个旁注：“无阳则阴独”；下边是正文：“复加烧

针，因胸烦”；下边又是一个嵌注：“面色青黄，肤瞶者难治，今色微黄，手足温者易愈”；以下又是正文：“心下痞，按之濡，其脉浮者”；这有一个小旁注：“关上”；“大黄黄连泻心汤主之；心下痞，而复恶寒汗出者，附子泻心汤主之；心下痞，与泻心汤，痞不解，其人渴而口燥者，小便不利者，五苓散主之”。后边还有一句话：“一方云，忍之一日乃愈”。这个也是后人做的注。

这个条文在《康平本》是顶格的条文。

其中嵌注“表里但虚”，在《宋本》被改作是“表里俱虚”，这个也没有太大的区别。正文的“口燥者”，《宋本》是“口燥烦”，另外《宋本》把这一段分成了四条，在第156条的“心下痞”之前，还有一个“本以下之，故”，“故”后边是“心下痞”，有这么五个字。那么咱们在学习的过程中再略加分析就是。

下面呢解读一下，还是用两个版本互相参照着来学习。一条一条地跟《宋本》一一对应着我们来学习。大家看一看这个条文，如果把条文里所有注解内容全部去掉的话，实际上这个条文，本身就像是一个众多医案，众多类似医案的一个总合，一个总结性的汇总。论述的就是太阳病经过了一再的误治，可能发生的一系列不良后果。换句话说，这等于是说太阳病的禁忌，所有这儿说的这些误治方法，都属于太阳病的禁忌。再一个就是误治以后对人体的影响以及一些治疗方法。

“太阳病，医发汗，遂发热恶寒”，太阳病本来就应该发汗，但是，使用的方剂跟这个病证不相适应的话，同样可能出现疗效不佳或者是病情加重的这个情况。

表证发汗治疗，有时候如果方与证不相适应的话，同样会出现一些不良后果。比如桂枝汤证，误用了麻黄汤的话，就会造成大汗出，病情不但不减，反而可能会增剧。这个地方论述的就是这种情况。也就是说“太阳病已发汗，遂发热恶寒”。为什么呀？就是因为方与证

不相应。反过来说，如果麻黄汤证用了桂枝汤也不会好的。

“因复下之，心下痞”，医者见太阳病发汗不解，反而重了，于是又用了泻下的方法治疗。大家注意，我们近期学的条文里面，此类的条文论述的就非常多。本来是太阳病，治不好然后用下的方法，甚至直接对太阳病用下的方法。我们从中可以体悟到什么问题？至少汉朝前后那段时间，社会上的医者误用汗下法的机会非常多。本来是一个表证，发了汗以后没有好，反倒是发热恶寒更厉害了，又用了泻下的方法，泻下以后出现变证了。出现什么变证？“心下痞”。这个心下痞咱们前边已经说过了，就是患者感觉胃中有痞满滞涩的这么一种感觉。

再接下来是嵌注内容，“表里但虚，阴阳气并竭”。这是对太阳病经过一再误治以后，对人体产生的危害所做的一个病理解释。发汗使人表虚，泻下又致人里虚；像这样连续的误治，伤人体的津液与生理机能，即“阴阳气并竭”。我们可以这样理解。

旁注“无阳则阴独”，又是对嵌注内容做的一个解释。这也能看出一个倾向，顶格的这些条文，《汤液经》作者的那个时期，就不重视病理和医理方面，对这些理论方面的一些诠释就少，让你自己从实际的，从他列举的这些医案集合里边去体悟。后人就倾向于作理论方面的理解，加的这些个解释啊，大部分都有这方面的倾向。这个旁注内容又对嵌注做了进一步的解释，可以理解为，这个时候的人体抵抗力极度的虚弱，相比之下致病因子就相对的强盛，就这么一个意思。

再接下来“复加烧针，因胸烦”，这是正文。虽然已经是一再误治了，但是病并没有好，医生看到这个病还不能痊愈，再吃药恐怕是不行，你像这个一般临床当中都这样，特别是一些有攻下作用的药，要是连续用，不良后果会非常严重，干脆就不给你药了，用烧针的办法来治疗。但是我们从经方理论来看，没有哪一种病需要用烧针来治疗，这也是误治。在人体经过误治以后，本来已经虚衰的情况下，再

用这种方法，本身用这种方法就包括精神刺激，包括针的刺激，就能致人大汗出的。前边条文已经论述了，像人比较虚弱了这种情况，再用这种方法，肯定对人的刺激就非常严重了。人体肯定会产生各种各样的不良后果。这个地方讨论的是什么？就是因为这种治疗之后，患者出现了严重的虚热证，热象非常得严重。

下边有一段嵌注：“面色青黄，肤瞤者难治，今色微黄，手足温者易愈”。这个实际上是作者对正文所论述的太阳病经过这样的一再误治之后，产生的不良后果，所做的一个补充。“面色青黄”就是那种铁青色又偏黄；“肤瞤”就是肌肤跳动。这都是人体组织严重失养所造成的一种危候，非常严重了，所以这里说难治。下边这一种哪，像这样的人手足温哪，面色仅仅是发黄的人体，他胃气还存在，所以还比较容易治愈。如果我们作为字面上理解的话，这些嵌注内容，也包括旁注内容，没有什么明显的不妥。他只是想把原文跟大家介绍更为详尽一些，更为贴近临床一些，但是他偏离了正文所论述的重点。正文论述的是什么？论述的是经过这些误治以后，出现了热证，该怎么处理，这是正文论述的重点。加上这些东西既没有具体的治疗方法，又没有具体的症状，实际上对正文应该说产生了一定的误导。这个误导到最后出现什么样的后果？就是通过这些注解，然后后人在解读的过程当中，感觉这个条文论述的太杂了，就干脆把这个条文分成几段。不要简单看这个分段啊，对后世解读条文的影响非常大。

接下来就是下边的条文，我们现在知道整个这是一大段条文，分段是后来分的，有相当一部分内容是加的注解。我们再往下来读的话，就是“复加烧针，因胸烦”之后这一部分内容，应该是跟上边的内容是接着的。这个条文，把注解内容剔除出去，我再跟大家读一下：“太阳病，医发汗，遂发热恶寒，因复下之，心下痞，复加烧针，因胸烦，心下痞，按之濡，其脉浮者，大黄黄连泻心汤主之”。原来这个条文是这个样子的。在这一段条文里边，我们明显看出来，出现了两个“心

下痞”。看似这是重复，《汤液经》的作者在成书的时候，受当时条件限制和作者的写作习惯或者是表达方式，他们是相当严谨的，而且是尽可能的一个字不多。但是在这个地方，却出现了两个“心下痞”。实际上这两个“心下痞”是特有所指，有自己特殊的意义。前面的“心下痞”是因为误治所致；后面的“心下痞”是指虽然经过“复加烧针”的进一步误治，并且出现了“胸烦”的症状，但是之前的，因“复下之”所致的那个“心下痞”症状仍然存在，第二个“心下痞”，实际上指的是这个。大家回头看看条文，是不是这么一回事儿？实际上就应该这么理解，根本就不能断开的。但是到了《宋本》，就给分开了。也就是说将“复加烧针”之前的这些病因和“胸烦”这个症状，从大黄黄连泻心汤中分离出去。你分成两段不就分不出去了么？那么分出去以后，“大黄黄连泻心汤证”成了什么了？就成了“心下痞，按之濡，其脉浮者”，就成了这个了。就将“胸烦”这一个大黄黄连泻心汤的主证，一个很重要的症状，一下子就排除到这个方证之外了。大家想想这种做法，对于后世的解读的误导得有多大？而且我们从临床统计资料来看，这个“大黄黄连泻心汤证”确确实实有“胸部烦热”的症状。我们如果参照一下《康平本》，这个第154条应该怎么解读啊？应该这么理解：“经以上误治后，患者如果表现为胸烦而心下痞，按之濡，其脉浮者，大黄黄连泻心汤主之”。这样，它的意思才能是全的。那么这样，我们再看看以上误治都有了，再参照误治的方法，整个条文前后就贯通起来了，而且这是原文的本义。像这个地方这么理解，可能在读《伤寒》的历史上，我们这是第一次。因为我们是把《康平本》和《宋本》参照着解读的。《康平本》给我们带来了更多的、新的，特别是真实的信息，我们能够把条文还原到原貌，而且我们能够把他读得更加准确一些。那么这样呢，“胸烦”也是大黄黄连泻心汤的症状反应之一。

那么“胸烦”在这个地方，就是半表半里有热的一个症状反应。

“心下痞，按之濡”，一是有里热证，二是没有明显的里实证。所以说“心下痞”是因为里热造成的。“按之濡”，就是说没有里实证。

“脉浮者”，我们要是看临床统计资料的话，不仅仅是浮脉，浮脉只是其中一个，而且脉象非常复杂。这个地方特别提出了脉浮，是有意的在强调这是一个热证。浮脉视为热证之候。

“关上”这个旁注，意思就是仅指“关上”现浮脉，这是他的本意。因为热而造成的心下痞，心下不就是胃的部位吗？要是应之于脉的话，就必然为关上浮，这应该是王叔和的理解。但是他由于对原文的解读带有不全面性，所以他就忽视了“胸烦”这个症状，其实“胸烦”也是大黄黄连泻心汤的主证之一啊。而且从临床的统计资料上看，它的出现频率比心下痞出现的频率还要高。如此看来，这个旁注的作者，不但没有全面的理解条文的本意，而且他还犯了一个错误。什么错误？犯了偏于机械地套用脉诊，而且这种机械地套用脉诊的问题，一直延续到今天。就这样往里面硬套脉象的这种做法，就使脉诊逐步的发展为僵化，什么样的证，必然见什么样的脉。在经方里面根本就不是这么回事，这是值得我们大家注意的。这个地方治疗就是用大黄黄连泻心汤。

大黄黄连泻心汤证的病理就是：半表半里的热证兼里实热证。

这个方子在《康平本》由三味药物组成，但是在《宋本》里面只有两味药。这三味药是：大黄二两，黄连、黄芩各一两。《宋本》在方后注解的后面加了一个按语：“臣亿等看详，大黄黄连泻心汤，诸本皆两味，又，后附附子泻心汤，用大黄黄连黄芩附子，恐视前方中亦有黄芩，后但加附子也，故后云附子泻心汤，本云加附子也”。

那么在这个按语里边，我们能看出些什么来？

宋代校正医书局在校正这本书的时候，按语里边说得很清楚：“诸本皆二味”。很可能当时能找到的所有的版本，都做了参照。但是从

这儿，我们明显能看出，绝对不会包括《康平本》这个版本。说明他没有见过《康平本》这种版式的。这是第一个问题。

第二个问题呢，《金匱要略》当中也有这个方剂，方名是“泻心汤”。药物组成和剂量与《康平本》中的这个方剂是完全相同的。这个可以佐证《康平本》这个方剂不是错的，绝对是对的。同时也能佐证《康平本》本身的真实性。另外还能证明什么？还能证明当时的校正医书局在校正《伤寒论》的时候，还没有发现《金匱要略》这个书。假设说《伤寒论》刚刚校正完，就发现了《金匱要略》，在《金匱要略》当中，又发现了“泻心汤”这个方子，他反过来还来得及对《伤寒论》再进行修改。这肯定是发行出去了以后，才发现了《金匱要略》。这是第二个问题。

第三个问题，从林亿他们所加的按语当中，对于方剂中药物缺味的校刊过程，是非常严谨的。宋代及以后的历代的注家对《伤寒论》所持的态度，非常慎重严谨。作为宋代官方的权威机构校正医书局那些人，都是专家呀，他们在明显地看出有问题的情况下，没有采取加补的这种办法，宁愿加这么一大堆的按语也不做改动，而且还一直延续到今天。这就说明后来的人，对这个《伤寒论》本身这个态度非常的严谨。

这个方剂当中黄芩黄连都是寒性的去热的药物，两味药特别是对半表半里的热也包括里热，有很好的清除作用。大黄在这个方剂当中，主要的作用就是助黄芩黄连清泻浊热，我们从大黄在这个方剂当中的作用，可以进一步加深对这个药物的理解。这个方证因为没有里结实，方中只用了大黄，没有承气汤中枳实、厚朴之类的行气消胀的一些药。可见大黄不是祛里结实的一个专用药。它的主要作用就是强化和它配伍的药物的泻下的力量。它和下瘀血的药物，就能强化下瘀血的作用，比如抵挡汤、抵挡丸；如果与温热药配伍的话，它可以下寒，比如大黄附子汤；与行气消胀的药配伍，还可以下实，比如三个承气汤；跟

祛水的药配合的话，也可以加强祛水的力量，比如大陷胸汤之类的。那么这个方剂在这个地方，就是祛热。它跟黄芩黄连配伍，主要的作用就是用来下热。

这个方剂也是个汤剂，但是煎法比较特殊。他要求把这三味药，用开水进行冲泡，而且浸泡的时间也不长，咱们在临床当中可以灵活的应用。你要是如果说根据病人的实际情况，病如果重一点，体质好一点，直接为他熬汤剂也没有什么太大问题。

我自己的案例，有一个人牙龈肿，还有一个人是破鼻子，这两个病人我都是用的这个方剂。我这儿都是散剂，我要求他们喝的量，比其他药物稍微少一点，告诉他们中病即止。结果吃了就好了。但是，得符合本方证。

大黄黄连泻心汤证：

症状：心下痞满、胸痞满、胸痛、胸中滞痛、脘痞、胃痛腹胀满，衄血：鼻衄、肌衄、目衄，吐血、呕血、咳血、便血，口干渴、小便短赤、大便秘结。

舌质：绛红、淡红、晦暗瘀点，舌稍褐色，舌面溃疡。

舌苔：黄、干燥、少津、苔厚、苔薄、苔腻。

脉象：数、弦、滑、有力、无力、濡、涩、沉、缓、大、浮、虚、弱、微、洪、迟、芤、紧、实，脉象表现得非常复杂。

大黄黄连泻心汤所治疗的现代疾病：急性溃疡性口腔炎、口腔溃疡、上消化道出血、胆道出血、急慢性胃炎、急性胃肠炎、非特异性结肠炎、消化性溃疡、细菌性痢疾、胆囊炎、化脓性胆管炎合并胆道出血、伤寒（西医副伤寒之类的伤寒）、急性阑尾炎、慢性阑尾炎、酒客热痞（中医说法）、贲门撕裂、高血压、高血脂、动脉血管硬化、脑溢血、脑血栓形成、心律失常症、血卟啉病、再生障碍性贫血、支气管扩张合并感染、肺结核、肺炎、急性支气管炎、肺性脑病、支气管扩张、胸膜炎、多种原因所致的咯血、鼻衄、精神分裂症、癫狂、

失眠、头痛、肝豆状核变性、白喉、急性咽炎、化脓性腮腺炎、急性口腔溃疡、口鼻生疮、鹅口疮毒、三叉神经痛、面瘫、耳疖、眼痛、针眼、风驰疮疖、风弦烂眼、天行赤眼、急性角膜炎、角膜溃疡、眼外伤、目衄、鼻衄、齿衄、牙痛、唇肿、急性结膜炎、表层巩膜炎、沙眼性角膜炎、急性虹膜睫状体炎、子宫内膜异位、多汗症、脂溢性脱发、急性湿疹、带状疱疹、生殖器疱疹、烧伤、肾盂肾炎、糖尿病性肾功能不全、银屑病、慢性骨髓炎、乙型脑炎、急性扁桃体炎、疮疡、子宫出血、痔疮出血、牙龈炎、外伤前房积血、失血性休克。涉及到的病非常多，涉及到的病变部位也非常多。

接下来是《宋本》的第 155 条。论述的是太阳病经过了第 153 条论述的那种误治以后，出现的与大黄黄连泻心汤证比较近似，但却是陷于机能沉衰的阴性证的这么一种情况。因为是同一段内容，所以解读第 155 条的话，就应该这样读：经以上误治后，患者如果表现为胸烦（这儿不能离开这个胸烦）、心下痞、而复恶寒汗出者，附子泻心汤主之。这样这个条文才是一个完整的内容。

那么这个“心下痞”，意思也与上一个条文“胸烦、心下痞”的症状是一样的。“而复恶寒，汗出者”，论述的是在大黄黄连泻心汤证的基础上，因人体素虚，或者误治太过，使人体陷于机能沉衰的阴性证而表现出来的症状反应。“恶寒”就是机能沉衰影响到循环系统，造成循环机能低下，营养不能达到“四末”，体表部分有点“失养”，患者主观上感觉冷。跟表证提高了体温之后，形成抵御外界致病因素的那种机制不同。“汗出”呢，也是因为机能沉衰之后，俗话说就是“出虚汗”。实际上这是人体对体表汗腺的控制能力不足了，汗液失控。

就因为既有大黄黄连泻心汤证，同时又陷于机能沉衰。所以用“附子泻心汤”来治疗。

附子泻心汤就是大黄黄连泻心汤原方加了附子。如果结合到临床

的话，大黄黄连泻心汤证不仅仅局限于“胸烦”和“心下痞”，而且这个阴证呢，同样的道理，也不是只局限于“恶寒汗出”，凡是符合这个病理特征的症状反应，都可以包括在这个范围之内。比如，精神不佳，但欲寐，可不可以？完全可以的。脉又细又沉又弱，可不可以？也可以的啊。

大黄黄连泻心汤证没有陷于阴证的时候，也有可能出现这种脉，是不是？所以说呢，这儿应该活着看。那么这儿呢只是给你列举了比较典型的症状。

附子泻心汤证的病理：阴性的半表半里热证兼里热证。

通过学习这个条文，我们至少应该弄清楚下边的这几个问题：

一个是在经方的病理辨证中，寒热与阴阳的关系。如果仅仅论寒热，寒则为阴性，热则为阳性。但是当“寒热”与“阴阳”同时出现的时候，那么寒热的阴阳属性则随着阴阳而变化。为什么咱们在这儿强调这个事儿呢？今天学的附子泻心汤的这个方证，就是一个典型的例子。本来是大黄黄连泻心汤证的这个基础，这是一个典型的阳性热证，但是当出现机能沉衰的阴性证之后，尽管仍然存在着所有的大黄黄连泻心汤证的症状反应，就是因为出现恶寒汗出，有这一类的阴性证的反应，整个方证的性质就随之变成阴性证。就成了一个机能沉衰的阴性证。在这需要跟大家提醒的是，这可不是单纯的做一些文字游戏。因为这其中啊，蕴含了人体的生理病理的内在关系。附子泻心汤证，看着一大堆的热象，要仅仅用大黄黄连泻心汤来治的话，不单单是疗效不好，而且还很有可能出现比较严重的后果。

下面是第 156 条：

“心下痞，与泻心汤，痞不解，其人渴而口燥者，小便不利者，五苓散主之”。《宋本》在这个条文之前有“本以下之，故”，那么接上以后就是“本以下之，故心下痞，与泻心汤，痞不解…”。

这个 156 条啊，应该有经上面误治后，患者如果表现为：“胸烦，

而心下痞，与泻心汤，痞不解，其人渴而口燥者，小便不利者，五苓散主之”。这个条文应该是这样的。

那么这个条文论述的是什么？论述的是太阳病经过一系列的误治之后，出现了半表半里的热证，既兼有里热证，又有里饮证的这么一种情况。那么“胸烦”和“心下痞”就是指的大黄黄连泻心汤的方证。但是，与泻心汤之后，反而是“痞不解”的这么一种情况。从这个条文后头的治疗方剂，我们可以知道，这儿的“痞不解”仅仅是指“大黄黄连泻心汤”方证当中的“心下痞”症状没有解除，“胸烦”就应该不包括了。大家想想是不是这么回事？绝对是这么回事。如果还有“胸烦”，因为已经服了泻心汤，完全可以治疗那个病，这其一。再一个，如果有严重的“胸烦”的话，五苓散也治不了啊？所以言外之意，“胸烦”症状包括一些其他的“泻心汤证”就已经基本上消失了。这儿的“痞不解”已经不是泻心汤的治疗范畴了。那么需要什么啊？需要进一步审视这个人有没有其他类型疾病，一看人又渴口又干，小便还不利，很明显这就不是大黄黄连泻心汤治疗的范畴了。是典型的里饮证，因为有小便不利，这就是典型的体液代谢不好了，是五苓散证。应该用五苓散来治。

这个条文还延伸出另一层意思，我们必须得理解到这个层面上。也就说五苓散证在某些情况下，也可能存在心下痞的症状，这样理解这个条文就比较完备了。

条文最后附了“一方云，忍者一日乃愈”，这个说法似乎没有道理。如果是真正“五苓散证”的话，绝对没有说忍一天让身体恢复恢复就可以痊愈，没有这种可能性。要有的话，五苓散本身就没有存在的价值了。

下面把这四条做一个小结：

本为太阳病，医者以发汗的方法治疗，但因方与证不能相应，随即出现了发热恶寒的症状；因此医者又施以泻下的方法，而致患者出

现心下痞；那么见病不得愈而再用烧针给予治疗，造成患者出现胸烦的症状；如果胸烦的同时又现心下痞，且心下按之柔软，其脉浮的，为大黄黄连泻心汤主治之证。如果胸烦且心下痞，同时又恶寒汗出的，为附子泻心汤主治之证。如果胸烦心下痞，服泻心汤之后胸烦等热证消失，而心下痞却不得解，患者同时表现为渴而口燥和小便不利的，则为五苓散主治之证。

伤寒汗出解之后、胃中不和、心下痞硬、干噫食臭、胁下有水气、腹中雷鸣、下利者、生姜泻心汤主之、（157）

生姜四两切 甘草三两炙 人参三两 干姜一两 黄芩三两 半夏半升洗 黄连一两 大枣十二枚擘

右八味、以水一斗、煮取六升、去滓、再煎取三升、温服一升、日三服、①

注：《宋本》于“日三服”之后有如下文字：

附子泻之汤，本云加附子。半夏泻心汤、甘草泻心汤，同体别名耳。生姜泻心汤，本云理中人参黄芩汤，去桂枝、术，加黄连并泻肝法。

胡希恕：伤寒依法当发汗，发汗汗出，伤寒在表之证已解了，可是里面出问题了，但这并非发汗造成的。此人可能胃根本就不好，平常就有，但不明显，大病之后就表现出来了，胃不和，心下痞硬，干噫（即是嗝气），食臭（伤食的味），食物不消化的味道，胁下有水气，胁下就是心下，肠子里面有水也会响，腹中雷鸣，水走肠间有声，且声音大如雷，下利者，生姜泻心汤主之。这个方与半夏泻心汤是一样的，只不过是在半夏泻心汤中加生姜，干姜减量。此方噎逆较明显，生姜配人参、甘草、大枣更能健胃，所以生姜特别加量，看起来上方没什么区别，但临床上体会，凡是腹中雷鸣，心下痞硬，呕逆下利或

不下利，干噎食臭最重要，如果有干噎食臭用半夏泻心汤不行，这是二方主要不同点，其他的都差不多，此方子偏于一般的胃肠炎的机会多。

用此方要注意一点，用此方容易发生晕眩，本来治呕吐下利的，吃此药后反倒吐的厉害，泻利无度，这不要怕，必好不可，此方去水气的，力量相当大，姜加重了，半夏、干姜皆温中去水，半夏下气去饮。有缓利的，大便老溏，同时有伤食的，吞酸，用此方有良效。但有时有此种冥眩的情况，是发挥作用，而一时出现一种特殊的状态。半夏泻心汤，甘草泻心汤，生姜泻心汤都是常用的。

李冠杰：这条是顶格的条文。《宋本》在条文后边加了后世注家的一段文字，没有多大的意义，自己看看就行了。

咱们解读一下：

“伤寒汗出解之后，胃中不和”。“伤寒”就指太阳表实证了，它本来就应该发汗解表，但是条文论述的却是表证发了汗以后解除了，但又出现了胃中不适的症状。实际上，这个地方论述的是表证治疗过程中出现的另一类变证的情况，就是说大概治疗方向应该没有错的，表证也能解除了，但是治完了以后，又出现了其它的症状，现在可以说它又出现了里证。为什么在正常的治疗状态下，出现不正常的变证？大致应该有两个方面的原因：一个是所用的发汗剂虽然说方与证基本相应，很可能护理不当等原因致汗出太多，诱发里虚；或者是方剂和病人的症状之间存在着一定的偏差，可能也差不了许多，但是多少有一点偏差。第二方面的因素，就是人体本来就虚弱，本来就有里虚证的倾向，也许发汗过多诱发里虚，导致里虚证凸显出来，表现为“胃中不和”的这种症状；或者说这两方面的因素都有。

下面看看症状。“心下痞硬”，前边提到过，它这是典型的泻心汤证之类的一种症状反应，主要的原因是里虚造成的。像这一类的做腹诊时，病人主观上感觉到胃中痞塞不通，会有抵抗感，有比较结硬

的感觉。如果按现代医学的解释，大概就是胃部有炎症一类的疾病。

“干噫食臭”，这个“噫”是一个多音字，它一个音是（yi），按（yi）读的意思是文言文里的一个叹词，表示感慨、悲痛、叹息之类的意思；另一个读音是（ai），读作（ai）的时候指的就是食饱，或者积食以后胃中的气从口中出来，并发出声音的情况，在这个地方它应该读作（ai）。“干噫食臭”就是病人噫出的气体有未消化食物的味道，我这里的俗话叫“有生食味”，还是说一种食物消化不良的反映。但是消化不良的情况很多，如果病人表现为这样，或有胃中嘈杂、吐酸之类的，以“干噫食臭”为比较突出的症状的，这就是“生姜泻心汤”的一个特征性的症状反应。一旦有了这种症状，生姜泻心汤的方证基本上就可以确立了。如果再有其它方证，可以和其它的方剂合方。

“胁下有水气，腹中雷鸣”。“胁下有水气”是对生姜泻心汤证做的一个病理解释，并不是一个症状反应，胡老把它解释为胃中停饮。

“腹中雷鸣”指的就是肠鸣亢进，噜噜有声，这就是比较重了，古人把这个解释为“水走肠间”。

“下利”在这个地方就是因为消化不良，消化道内的食物不能充分的被吸收，而造成的一种下利的情况。也就是说大便溏泻，但是又达不到“下利清谷”的程度。

生姜泻心汤证的病理，就是里虚寒证合并半表半里的热证，并伴有水实证，应该是寒热错杂的一个方证。这个方证和半夏泻心汤证、甘草泻心汤证主要的症状反应差不多，因为它们的药物组成非常接近，只是有个别的症状反应不太一样，它们的病理基本上是一样的。

胡老也特别强调过，这个方剂在临床中容易出现“瞑眩”反应。生姜泻心汤可以这么理解：它在半夏泻心汤证的基础上，又表现为下利明显、干噫食臭两个比较典型的症状。这个方剂喝了以后，容易出现下利更严重的情况。

我在这方面有过教训，这个跟大家可能不止一次的说过了，这个医案对我来说，一生都不会忘的。就是一个朋友的母亲来我这儿看病，她的症状非常明显，就是“半夏泻心汤证”伴有“干噎食臭”。我就给她生姜泻心汤，后来我这朋友打电话说：服了这个药以后，反倒是她泻得更厉害了。因为当时没有经验，我就跟他说把药停一停。后来这个朋友还抱怨我：我母亲吃了你的药以后泻的更厉害了，差一点拉到裤子里，后来又吃了别人的中药，很快就好了。我当时觉得心里很别扭，到后来想来想去，记得胡老好像说过这类的事，我翻开胡老的讲座看了看，专门有一小段就是论述这个方剂的“瞑眩”反应的。这个事对我的触动很大，后来再遇到瞑眩反应，就不像以前感觉那么意外了。因为当时这个病人的症状太明显了，她就是典型的生姜泻心汤证。如果说她这么典型的生姜泻心汤证，服了药以后反倒是出现变证（那时候就是认为出现变证），那么经方理论都值得我重新去审视了。那时候自己逼着自己临床中全去用经方，也是刚开始时间不长。这个医案以后，那个朋友一家人好长时间没有人在我这看病，现在这段时间，他兄弟、弟妹，包括他父母亲及亲戚，甚至他的员工等等，几乎天天有人来我这儿看病。这也是时间长了以后，他又在德州找了一个中医，吃了一段时间药，后来才发现别的医生的药跟我的不一样，我的药下去就能治病，就有效，但别的医生的药吃了几个月了，一开始有点效，后来效果就不明显了。

从这个事以后，我对瞑眩反应做了一些思考，后来慢慢地就抓住它的规律了。凡是这个方剂治这种证，但是服了以后这种证反倒重了，首先要考虑是不是瞑眩反应，这是其一；再一个，可以借助病人的病理再去考虑。有一个老太太，她是脑积水，我给她的方剂是真武汤合上当归芍药散，她服了以后，每天下午会出现近 20 分钟类似休克的状态。实际上那就是一种瞑眩反应，减减药量就会情况好一些。还有的喝了真武汤以后嗜睡，一睡两三天，老是躺着睡，叫都叫不醒。这

也是瞑眩反应，因为它们的症状都非常明显。这样对瞑眩反应的认识面就会宽一些，再参照病理，一旦遇到这种情况，也不至于手忙脚乱。

昨天有一个小病人，他父亲带他来看病。他前一段时间感冒了，我给他小柴胡汤合麻杏石甘汤，后来这段时间，这孩子吃饭猛吃，比以前饭量大了不少，特别是前天晚上吃得更偏多一些，到了下半夜就吐了，之后就开始发烧。他父母就给他服了一次小柴胡颗粒，早晨来我这的时候，体温还有点偏高，看着也没有精神，做腹诊的时候按他胃部有点满的感觉，再加上他吃得多，偏于实证，就给了他一剂大柴胡汤，3克左右，后边都是小柴胡汤。昨天服了药以后，他母亲晚上又给我来电话，说孩子一天一直在发烧，已经烧到快39度了，很担心。我就跟他说不要紧，烧到这种程度很快就要好了。今天早晨我打电话问，他父亲说孩子没事了，好了，说昨天晚上打完电话过了有一个多小时，体温就逐渐的下降，到了睡觉以前就降到37度左右了。实际上这都是些瞑眩反应。像这个孩子前边也服过柴胡汤，也喝过小柴胡颗粒，为什么还能认定他是小柴胡汤证？他的症状确实不明显，但是比较典型，《伤寒论》条文里有“呕而发热，小柴胡汤主之”。他服了小柴胡颗粒效果不明显，是什么原因呢？现在的小柴胡颗粒质量令人很难信得过，这是其一；再一个就是之前若干天他吃得比较多，积攒了一些能量，人体因为摄入食物多，消化得比较好一些，也就是说人体状态在往好的地方发展，在走上坡路的过程中出现的情况。如果身体恢复得比较快的话，他也会症状比较明显一些。另外我问过他有往来寒热，一阵阵发冷，这也是用柴胡剂比较明显的一个症状了。

做个小结：伤寒病，经发汗后表证已解，但是却出现了胃中不和的情况，患者表现为心下痞硬，干噎食嗅，并且胁下有水气，腹中雷鸣下利的，为生姜泻心汤主治之证。

这个方子由八味药组成：生姜、甘草、人参、干姜、黄芩、半夏、黄连、大枣。实际就是半夏泻心汤加了一味生姜，生姜的量加得比较

大一些，是四两，把干姜的量由三两减为一两。所以这个方剂的适应证和病理状态与半夏泻心汤非常接近，但这两个方剂的区别，也就是“干噎食嗅”这个证，是一个鉴别点。

从这个方剂中干姜和生姜同用的配伍，可以显示出经方组方的严谨性。虽然干姜是由生姜加工而来的，通过日晒或用微火烘干制成的，但是两者的药性显然存在一定的差距，中医界解释最多的就是干姜温中，守而不走，生姜则是走而不守，说明干姜温中补虚的力量大于生姜，而生姜解表的作用又大于干姜。尽管这样，这种解释对方剂里生姜和干姜之间到底存在什么样的差距，解释得还不够恰当，而且还有干姜的比例大于生姜的问题。咱们从半夏泻心汤、甘草泻心汤和生姜泻心汤做一下比较，只有生姜泻心汤有这种组方的方式，而且是生姜大于干姜，非得是这种组合才能治疗“干噎食嗅”，其他的两个方剂治有类似症状反应的疗效就不如它，这里边区别就在干姜和生姜的药性方面。

再进一步地分析还可以发现，经方组方的变化完全是从临床实践而来的。经方这两本书没有任何一个地方是解释药性的，只有《金匱要略》里有一个地方提到了本来应该用麻黄，但是不用麻黄用了杏仁，恐怕那个解释不是出自仲景原文，是后人加的。像生姜泻心汤这个方剂，它的药物变化在于两味药性基本一致的药物上，而且出现了变化以后，方剂的适应证也随之发生了变化。

如果从这个角度，我们再重新审视一下时方的组方特点，你不难发现，它实质上就是医者许多地方的主观臆想，自认为是随证加减，越加药味越多，自己心里感觉很好，因为是凭着自己对药物认识的知识，用那套药物归经的理论对药物的理解，感觉根据辨证加上那些药以后肯定疗效很好，但实际上常常临床中越加药味越多，到最后自己都得不到要领，方剂也时效时不效。这种总结就是跟临床实践不能很好地接轨。还有一些现象，用时方理论组方的也有跟生姜泻心汤类似

的情况，比如白芍、赤芍同用，常常是白芍 15 克、赤芍 15 克；比如苍术、白术同用；独活、羌活同用，这种情况很多。但是这种同用，比如白芍、赤芍同用什么意思呢？它就说赤芍补血的力量比白芍要大，如果单用赤芍 30 克，或单用白芍 30 克，与赤芍和白芍各用 15 克在方剂的适应证有什么变化，没有一个人能说出来。所以说这些东西都不太准确，理论上言之凿凿，说的非常确切，但实际疗效却时有时无，这个问题的关键就出在对所掌握的药物药性的理解过分自信。我常说，实际上咱们人类到现在对任何一味中药都没有理解透彻。真正用好中药就是经方这个样子，从实际临床中找到药物和症状之间存在着什么关系，去研究这个就是了。像时方里的药物归经理论，如果按经方这一套理论和组方的原则去审视经方里有的药，它都不太准确（当然有的药物五脏六腑都归了，那就不好说了）。

下边看看在生姜泻心汤证的病理状态下，临床中会出现什么典型的症状反应，也就是说方证。像胃脘痞满，泻泄（也就是下利了），肠鸣，恶心，胃脘胀痛，纳呆，干噎食嗅，是这个方剂出现的频率比较高的一些症状。

舌质：红，淡红，胖大，有齿痕，暗淡，大体是这么几种。

舌苔：苔白，白腻，薄白，黄，滑。

脉象：弦滑，弦紧，沉滑，弦细。

统计资料看，在生姜泻心汤的病理状态下，常见的一些现代疾病有：胃下垂，急慢性胃肠炎，胃炎，胃溃疡，胃功能紊乱，胃扭转，胃迟缓扩张，胃酸过多，十二指肠球部溃疡，十二指肠吸收不良综合症，胃窦炎，胃扩张，慢性消化不良，窦性心动过缓，心律失常，失眠。

实际上这个方剂跟半夏泻心汤的方药组成基本上一样，半夏泻心汤出现的一些现代疾病，在这个方剂里也完全有可能出现。只是说临床统计资料里这个方剂应用的几率没有半夏泻心汤高，所以统计到的

现代病也比较少。如果真正客观的审视这些资料，应该是在半夏泻心汤证对应的那些现代病的基础上，再加上它所能治疗特有的疾病，比如胃酸过多这类的病，半夏泻心汤肯定就不如它治疗的好一些。

伤寒中风、医反下之、其人下利日数十行、谷不化、腹中雷鸣、心下痞硬而满、干呕、心烦不得安、医见心下痞、谓病不尽、复下之、其痞益甚、此非结热·（注）但以胃中虚·客气上逆·故使硬也·（经）甘草泻心汤主之、（158）

甘草四两炙 黄芩三两 干姜三两 半夏半升洗 大枣十二枚擘 黄连一两

右六味、以水一斗、煮取六升、去滓、再煎取三升、温服一升，日三服、①（注）附子泻心汤·本云·加附子半夏泻心汤·甘草泻心汤·同体别名耳·生姜泻心汤·本云理中人参黄芩汤·去桂枝术·加黄连·并泻肝法·

注：《宋本》此处有林亿等人按语如下：

臣亿等谨按：上生姜泻心汤法，本云理中人参黄芩汤，今详泻心以疗痞，痞气因发阴而生，是半夏、生姜、甘草泻心三方，皆本于理中也，其方必各有人参。今甘草泻心中无者，脱落之也。又按《千金》并《外台秘要》，治伤寒蠱食用此方，皆有人参，知脱落无疑。

胡希恕：这一段不仅说甘草泻心汤，同时给上面二个方剂，心下痞硬作解说。伤寒中风，无论伤寒或中风，依法全应汗而解之，而反下之，其人下利日数十行，因泻药，热邪内陷，而为协热痢，下利日几十次谷不化，是因泻下利，不是胃不消化。腹中雷鸣，与半夏泻心汤一样，心下痞硬而满，也是半夏泻心汤的痞硬而满，因泻下的作用伤了胃气。干呕心烦不得安，医见心下痞硬，见病未尽，复下之，其痞益甚，此非结热，不是阳明病，热结于里。但以胃中虚，本不虚因

泻药而致胃虚，所以客气上逆，不但外邪因胃虚而入内，而里面的水，也为客气，也往胃上涌，逆于上，故使硬满。甘草泻心汤主之。此方变化更小，只是把甘草增量，由三两变为四两，甘草主要缓急迫，这里心烦不得安，用甘草缓急迫，但此方也不只限于这个，金匱要略有，口腔溃疡类的病，挺奇怪的，非常有效，也要加减。凡是胃肠炎类的病，久而不愈，用此三方得当都有效。临床上大便溏，不爱吃东西，恶心肚子叫，心下痞硬，很多的，用此三方，偏于下利，干噎食臭，用生姜泻心汤，没下利只呕，心下痞硬腹中雷鸣用半夏泻心汤。

李冠杰：这个条文在《康平本》里面也是一个顶格的条文。

下面解读一下：

“伤寒中风，医反下之”，这儿的“伤寒中风”是指或者是伤寒或者是中风，都可以，就是说或是太阳表实证或是太阳表虚证。凡是表证不管是表虚证还是表实证，都应该以发汗的方法来解表。不同的是：表实证要用麻黄汤之类的方剂；那么表虚证要用桂枝汤之类的方剂。使用泻下的方法都是误治，所以这里说“医反下之”，阐明了这是一种误治。

“其人下利，日数十行，谷不化”，我们从这儿能看出这个医生在这里所用的泻下药是非常猛峻的。不单单是下利的次数多，一天数十行，这就太严重了；而且由于泻下得非常迅猛，以致于这个消化道里面的食物，根本就来不及消化就排出体外了，可见泻下剂特别猛峻。如此猛峻地泻下，必然会对人体的胃肠功能造成影响，致人里虚。

“腹中雷鸣”，跟刚才那个是一样的，是肠鸣的一种症状反应。在这种寒热错杂的病理状态下，既有里寒又有半表半里热的这种病理状态下，常见的这么一种症状反应。

“心下痞硬而满”，这也是三个泻心汤所共有的症状反应。但是在这个地方强调了一个“满”，这个“满”是由于重度地泻下之后，导致里虚寒所表现出来的虚满，不是实满。

“干呕”是胃气虚弱的症状反应。

“心烦不得安”是甘草泻心汤的一个典型的症状反应。这个“心烦不得安”的病理基础就是里虚，里虚得严重，造成的精神方面的一种症状。

你看生姜泻心汤，它这个病因是经过猛峻地泻下，但是咱们在实际临床当中呢，常常没有经过泻下而得这类病的，人体不是一天二天身体不好，都是比较虚弱的这一种，尤其是里虚。里虚的结果是什么啊？就是吸收功能非常差、非常弱，人体缺乏营养。人体缺乏营养以后，可能会造成各式各样的疾病。这个地方出现了“甘草泻心汤证”的话，就是“里虚”为主要的根源。因为神经系统失养，造成了精神方面的一些障碍。

“医见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚”，这儿用了一种具体叙述医案的方法。实际上来论述的是什么？论述的是抽象的理论。你看着好像是在讨论医案，具体的不能再具体了，有人物、有环境和症状反应，都有啊。医生看这儿还有心下痞呢，甚至连情节都有，认为这病还没好，还得用泻下药，结果让人吃了泻下药以后“其痞益甚”，症状更严重了。

但是按着经方的理论，是重病证、重病理，不重病因，是这样的原则。这儿如此详尽地讨论一个具体地治疗的过程，实际上这种论述的方法，可以加深读者的印象。只要结合实际临床，你讲医案，就容易听得进去，容易记得住，比较形象。但是咱们现在实际学习过程当中啊，要是真正地去讨论医案的话，有时候会对理论学习反倒造成一些不好的影响。为什么呀？所有的经方方剂，用现代医学的话，每一个经方方剂就像广谱抗菌素，治的是方证。只要具备这些方剂的方证，不管是什么病，都可以治。我跟同学们常常举的那个例子，就是说用理中汤来治粉刺，他得有理中汤证，那是一个典型的治里证的药，但是皮肤上的病它也可以治，只要有理中汤证就行。我治过也不是一

例，效果非常好。

如果这样去讨论医案的话，不能说凡是涉及到这个方剂的每个医案都要讨论，讨论一个医案就记住这一个，那么在临床当中用这个方剂的时候，就会受这个医案的局限。

实际上经方这都是一个一个的医案，特别是这一条，非常像一个医案。但是这个医案里边我们就不能那么去读了，应该把它升华到理论的层面上，只有这样，你才能真正掌握经方的这一套体系。这个地方它更重要的是什么呀？在讨论医案的过程当中，他把这个方证的病理蕴含在里边，一再地误治，势必导致人体陷于极虚的病理状态。具体到这个条文论述的是，经过了一番的误治以后，发生了甘草泻心汤证的这么一种情况。为什么没有发生四逆汤证呢？临床当中就有这种情况，你尽管误治得很厉害，人虚得也非常严重，但是却没有到阴证这种程度，反而是进入了一种寒热错杂的病理状态。从这儿我们能体悟到，临床当中人患病以后，这个病情、病理是非常复杂的，误治以后所造成的不良后果也具有多样性。具体到这个条文最后落到，就是“其痞益甚”，病情更严重了。为了更好地理解甘草泻心汤证，因为在学术上，有的学者把眼光着重于条文论述的这些误治的经过上边，认为这个甘草泻心汤证是一种急迫症。“下利日数十行”，心下痞而且还满，最终导致了“其痞益甚”，这就一连串的显得非常急迫。但是忘了一个问题，我们读经方应该读得进去，还得读得出来。如果不是经过这样的误治造成的甘草泻心汤证呢？那个急症何在？那个急迫症至少没有这么严重。这个方剂真正的关键点在哪儿啊？我认为这个方证的关键点在于一个“虚”，人虚得厉害。前边误治了，一再误治，误治后果那么重，就是造成了一个人虚，对人的损伤特别重。

下边我跟大家介绍两个医案，大家听听恐怕是会有启发的啊。

第一个医案呢，有一个 38 岁的女性病人，因为她的孩子发生意外夭折了，痛苦异常。过了不久就出现了一些精神方面的失常了。症

状是什么呢？每天下午到晚上，出现自言自语、哭笑不休。夜间勉强能够睡，但是要惊醒数次。心悸不宁、躁扰不安、精神恍惚，反正是精神方面的这些症状非常地明显。甚至有时候她独自乱跑，跟神经病差不多了。这样的状态持续了两个多月。到后来呀就听说有比较高明的医生、好的医生，她每天上午比较清醒，那么就迁就她上午清醒的时候，找这医生给她看病。当时看的时候，这个医生看她烦躁、懊恼、心下憋胀不适、口干舌燥但是不欲饮水、善太息、易激动，脉数大无力，一派虚象。苔白腻，就给了她甘草泻心汤，一开始就是甘草泻心汤的原方，服三剂，病情就大有好转了。后来在这个方剂的基础上进行了一点加减，连服十剂就彻底好了。这是一个医案。

还有一个医案是从《皇汉医学》摘过来的。有个大户人家的女儿，刚刚 16 岁，那个时候婚配得比较早，按我们现在的話就是已经订了婚了，书上说的是“已许配矣”，就是说已经许给别人了。她有一个很奇怪的疾病，这个疾病啊从来没听说过谁有过这种病。每天晚上等家人都睡熟了以后，她偷偷地起来跳舞。假如你偷偷地看她跳舞的话啊，而且她跳的那个姿势啊，原文怎么说的啊？是“俏妙娴雅”，跳的姿势还非常美。每当这个天快要亮的时候，她才自己去睡觉呢。她自己家人也观察她一段时间了，就是说她每次跳舞的样子和伴的曲吧，那个时候没有录音机什么的，大概是口里边哼的小曲什么的，都不一样。而且没听过，很奇妙，但是你也说不清她是哼的什么曲儿？实际上这是一种无意识的。每到白天呢就跟常人一样，没有不正常的地方。她自己也不知道，因为有时候问她，她自己不知道。但是你要是告诉她，说你晚上啊别人睡觉以后，你就起来跳舞，她就感觉非常惊讶、不相信。你不是跟我开玩笑吧？哪有的事儿呀？我晚上睡的好好的。大概就是这个样子。一家人感觉非常愁的慌，这是鬼使神差的，这到底得的什么病呀？而且呢还生怕别人知道，一旦别人知道了以后，她大概是许了门第比较高的一个亲戚，恐怕人家不要她了，恐怕

有害于她这个婚事。咱们现在说的看虚病这一类的。后来请了一个大夫，让她吃的就是甘草泻心汤。就是说吃了不数日，晚上跳舞的这个情况就慢慢地就自止了，就好了。后来结了婚以后，就正常的过日子了。

大家看这两个医案，比较有意思。这两个医案，他们的症状反应与我们学的甘草泻心汤的这个方证，好像是有点不怎么沾边。但是他们都有一个共同的特点，就是“虚”。你看前头这个，她孩子出现那个情况以后，她必定是多日不怎么吃东西，其后果就可想而知，跟“下”过，实际上是一个道理。那么后者呢，为什么出现这种情况？你可以想象，从这个医案地描述你可以想象，这肯定是一个大户人家的闺中小姐，一定是平时身体就比较虚弱的哪一种，大门不出，二门不到的那一种。

后边是旁注：“此非热结”，它提示这个地方，虽然有心下痞而硬满，但是他的疾病性质与纯热结那些大黄黄连泻心汤证的那种病理不一样，不是一种病。

嵌注内容是：“但以胃中虚，客气上逆，故使硬也”。它是对这个“心下痞硬而满”后的“其痞益甚”做的病理解释。就明确地指出这是胃中虚造成的。“客气上逆”，这是古人对疾病病理的一种认识。我们今天的认识大概是这两个方面：一个是胃部发生严重组织充血；另一个就是胃肠功能比较虚弱，饮的水，摄入的食物停于胃中不化造成地这一类的。像人参证，就是对食物、对水吸收能力差，造成心下痞硬。

这个条文重点论述的是因为误治，所导致的“甘草泻心汤证”在临床当中的主要的表现。它概括“腹中雷鸣”啊、“心下痞硬而满”啊、“干呕”啊、“心烦不得安”啊。《金匱要略》也有对这个方证的论述：“狐惑之为病，状如伤寒，默默欲眠，目不得闭，卧起不安，蚀于喉为惑，蚀于阴为狐，不欲饮食，恶闻食臭，其面目乍赤、乍黑、

乍白。蚀于上部则声喝，甘草泻心汤主之”。从这个条文里边论述，我们刚才讲那两个医案，倒是有一些因素包括在里边，从这里边能找到论述、理论方面的一些依据和症状方面的一些相近的地方。

总地说，为什么跟大家把这个甘草泻心汤说得这么多？这个地方是这个方证的一个特点，一般大家看一看这个方药组成的话，总是先想到半夏泻心汤，它跟半夏泻心汤这个症状表现会比较相似。但是一旦要出现这一类症状的时候，恐怕往往都想不到，如果在这种情况下，不用这个方剂治的话，大家想想这么虚的人，要是再误治了，后果就非常不好了。这个方剂的病理应该说跟半夏泻心汤和生姜泻心汤是相同的，都是里虚寒证伴有半表半里的热证，但是这个方剂当中的虚证，是一个重要的矛盾面。

下面做一个小结：太阳表实证或是表虚证，本当发汗解表，医者反用泻下的方法治疗，造成患者下利而且日数十行，甚至腹中食物不及消化而排出，腹中雷鸣、心下痞硬而满、干呕、心烦不得安，医者见心下痞硬，认为是泻下不够，病尚未愈，所以又施以下法，致使痞证更加严重的，为甘草泻心汤主治之证。这里的痞并不是纯热结，而是由于误下后造成的里虚所致。

下面看这个方剂。甘草泻心汤由七味药组成，但是这个方剂，《康平本》和《宋本》这两个版本都是六味药，方剂当中都没有人参，《金匱要略》里面的甘草泻心汤，它有人参三两。另外咱们根据《宋本》当中，宋代校正医书局林亿他们加的那个按语当中，我们知道，《千金》（就是《千金方》）和《外台秘要》这两本书当中所载的这个甘草泻心汤也有人参这一味。这就可见在《康平本》之前，这个《伤寒论》当中，可以说主要的版本这个沿袭的脉络里边，在这个方剂里边，这一味药就脱落了，没有了。今天咱们经过这么多的方面都可以证明这一点，所以说我们现在应该给予更正，应该有这一味药。这个方剂就是说在半夏泻心汤的基础上，由于虚证更加严重，所以说加了甘草

这么一味药，就是甘草的量加大了。

它的适应证呢，也就是半夏泻心汤证虚证更为明显了。虽然说从病理上说是这样，但是实际从临床当中，刚才我们那两个医案，最能说明问题了，这不是半夏泻心汤所能治得了的。值得我们注意的是，这个方剂中的甘草要求是用炙甘草，但是在实践当中证明，特别是在治疗口腔溃疡这一类疾病的时候，使用生甘草的效果要优于炙甘草；而且实际用量，往往比原方里的四两这个量还要大一些，常常是在六两以上。由此可见，这个甘草不单可以补虚缓急，它还有治疗因为虚热而导致孔窍部位的这些粘膜溃疡性疾病的这一类功能。那么，现代医学研究，说这个甘草啊，能刺激人体这个粘膜粘液的分泌，从而起到一个保护修复粘膜溃疡面的这么一个作用。这只是说用现代的科技手段可以看得到的这一块儿。说它为什么有这个作用？实际上还是不知道。但是这也毕竟是一个进步，可以让我们对甘草这一味药的功能理解得比较具体一些。所以说，对于像口腔溃疡、白塞氏综合征之类的这一类粘膜性溃疡疾病，这个方剂就有比较好的疗效。

我曾经有这么一个病人，70多岁一个老太太，他儿子、儿媳妇、孙子什么的，都在我这儿看病。后来在看病当中，他儿子就说：“我母亲口腔溃疡，十来年了，连绵不断、时好时坏，有时候好了几个月，过一段时间马上就又犯了”。我说：“见不到病人，我也不能这么给你药”。后来他说：“她来也不太方便”。我说：“这样吧，电话里问问吧”。我就在电话上问了问，我问他：“你有没有肚子里边咕噜啊？”她说：“有，常有！这一段时间才明显呢，我口疮疼得厉害”。我就给她甘草泻心汤，一共拿了五天的药，后来打电话给我说，这五天的药吃到三四天，基本上就好了，到现在快三年了，一直也没有听说她再犯这个病。

我们还要思路再宽一点，咱们不要把“甘草泻心汤”固定在口腔溃疡这类的疾病上，它不是专门治这种疾病的。在实际临床当中，对

于口腔溃疡这一类疾病的治疗，当病人有甘草泻心汤证的时候，我们换一种说法，如果这个病人有半夏泻心汤证，同时存在口腔溃疡，你用甘草泻心汤，就是效如桴鼓，非常得快。但是没有这个方证的情况下，疗效也不理想，甚至疗效都没有。这印证了什么？印证了经方理论里边，“方与证皆要相应”的这么一个原则的正确性。没有这个证的时候，就算是它的一个特征性的病，它也治不了。咱们从临床统计资料看，有治疗口腔溃疡记录的方剂，不是只有甘草泻心汤一个，还有其他的。像大黄黄连泻心汤、葛根芩连汤、茵陈蒿汤都有，甚至包括像有人说用血府逐瘀汤、炙甘草汤治疗顽固性复发性口腔溃疡，都有这样的记录。

我们根据刚才对甘草药性的分析，可以做一个延伸，假设这个病人表现为葛根芩连汤证，但是他同时又有口腔溃疡，那么你在葛根芩连汤的基础上，加上生甘草，疗效肯定会优于仅用葛根芩连汤。所以这是提高经方疗效的一个有效的途径，而且也不失为是经方理论“有是证用是药、有是证用是方”的一个灵活应用。要说再延伸，那里边问题就非常地深了。不有人说自己也可以组方，理论上说是可以的。但是我们现在在这儿得到一点启示，也是在经过了深入地学习研究之后，才能看到这么一条路，不是说随意地去加减，你得有充分的依据。

另外，《宋本》在这个方剂的方后注解的后边，宋代的校正医书局林忆他们加了一段按语，大家可以看一看。主要的内容呢就是说，原书这个方当中没有人参，经过论证，认为这是脱落无疑。我们今天解读，可以帮助我们佐证两个问题。一个问题是《康平本》与《宋本》是一脉相承的，不然的话，怎么可能这么巧合？其他的版本，包括《金匱要略》里边都有人参三两，就唯独这两个版本里边没有。我们说王叔和把这个《伤寒论》整理了两次，第一次整理完了就是《康平本》的样式，后来又第二次整理是《宋本》的样式。实际上在这个地方也有一些可以佐证的这个意味。还有一个问题，就是《康平本》应该早

于《宋本》。因为这两个版本都缺人参这一味，但是《康平本》中没有林忆他们加的这个按语。要如果说《康平本》晚于《宋本》的话，《康平本》里边也应该有这个按语才对。另外是这个宋朝在校正这个书的时候，没有见到《金匱要略》，所以采用《千金》和《外台秘要》来作为校勘。从这一点上，就能够看出历代学者对这本书态度的严谨。从宋代往后，加了按语以后，也没有人再作进一步的更正，一直维持原来的样子，包括宋代他们宁肯加按语，也不去作修正。

下边是这个方证。从症状看啊，主要有这么几大项症状：

泄泻、心下痞满、纳呆、口腔及阴部溃疡、肠鸣。这个方剂的统计资料做得不太好，症状统计得非常少，出现频率低呢就都给省略掉了。

舌质：红、淡、有淡嫩、胖大有齿痕。

舌苔：白腻、薄白、黄白、黄白腻、薄黄、白苔、无苔。

脉象：虚数、细沉、弦数、滑数、弦细，这个脉象比较明显啊，能够看出虚象比较明显。

在现代病方面：急慢性胃肠炎、十二指肠球部溃疡、胃窦炎、胃下垂、消化不良、溃疡病、胃脘痛、慢性胰腺炎、肝胆疾病、肠道易激综合症、严重腹泻导致的低钾症、食道裂孔疝、胃脘颤动、噤口痢、白塞氏综合征、口腔溃疡、淋病、尖锐湿疣、急性尿道炎、外阴龟头溃烂、女性阴周或前阴溃疡、舌溃烂、不眠症、神经官能症、癫痫、心房颤动、心力衰竭、艾滋病、外阴腐蚀。

我们学完甘草泻心汤以后，把这三个泻心汤简单地再回顾一下。咱不去作总结性的回顾，就说它们之间的差异。就说“心下痞硬、偶尔肠鸣下利”这一类的症状，这是“半夏泻心汤”的主要的症状反应；同时也是这三个泻心汤的常见的症状反应。在这个基础上，出现“干噫食臭”并偏于“下利”的，那么就可以确定为“生姜泻心汤证”；如果以出现“粘膜性溃疡”类疾病的，或者说是因虚而造成的“精神

方面疾病”的，即可认为这是“甘草泻心汤证”。这就是三个方剂的主要的区别点。

伤寒服汤药、下利不止、心下痞硬、服泻心汤已、复以他药下之、利不止、医以理中与之、利益甚（注）理中者·理中焦·此利在下焦·（经）赤石脂禹余粮汤主之、（注）复不止者·当利其小便·（159）

赤石脂一斤碎 太一禹余粮一斤碎

右二味、以水六升、煮取二升、去滓、分温三服、

胡希恕：本来是太阳伤寒，治错了，当汗，反服下药，所以下利不止，心下痞，这也是心下痞硬，一方面协热利，虚其胃。服泻心汤已，指甘草泻心汤，病已，就是病好了，不利了，但是医生还以他药下之，利不止，再吃泻心汤也止不住了，就用理中汤，利益甚，这是由于一再用巴豆剂下之，使肠道滑脱不收，理中者理中焦，治胃虚寒，此利在下焦，反复大下，使大肠失去收涩，在下焦，应用赤石脂禹余粮汤主之，此为收敛固肠的办法。吃此药还不止，是水谷不别了，当利小便，故此时必有小便不利，一利小便就好了。

这说明由于误下，而造成利不止的病，在下焦有二种不同的问题，一个是大肠滑而不收，用赤石脂禹余粮，另一个是水谷不别小便不利造成的，就利尿。赤石脂禹余粮，此二药固涩力量相当强，但真下有热不是虚脱时此药不可用，如痢疾等，滑脱不止可用。便血的可用桃花汤，后面有的。

李冠杰：这个条文在《康平本》也是一个顶格的条文。

下面解读一下：

这个条文论述的是太阳病屡经误下以后，造成胃肠功能虚弱，而导致的滑脱性下利和相应的治疗的方法。在论述的过程当中涉及到了

三个具体的治疗方剂。一个是汤药；第二一个是泻心汤；第三一个是他药。

因为经方理论重证不重病因。理论上说，这三个方剂具体是什么方剂？应该说不是论述的重点。所以这个条文里面，论述的也比较粗，没有说具体的方剂。但是我们今天解读，应该尽可能的正确地理解他的本意。这样对于我们理解条文的病理，有着比较重要的意义。

咱们看一下，“伤寒服汤药，下利不止，心下痞硬”。这里所谓的汤药，应该指的是承气汤之类的方剂。从这个服药后，“下利不止，心下痞硬”的结果来看，使用的泻下的方剂，还是比较猛峻的。不单单造成“下利不止”，而且也虚了里，出现了“心下痞硬”。

泻下以后没有好，“服泻心汤已”。由于这个条文是衔接的“甘草泻心汤”条文之后的，我们认为应该是指“甘草泻心汤”，或者三个泻心汤其中之一。因为泻心汤还有另一个方剂“大黄黄连泻心汤”。如果是这个方剂的话，里边有大黄，服大黄黄连泻心汤的话，他下利是不会止的。“服泻心汤已”，这个“已”的意思就是说病已经解除了。

但是“复以他药下之”，他肯定是没有全好，因为全好了的话，有必要再让他服下药吗？没有必要了。应该是存在什么样的问题？就是“下利”的症状好了，但是还有“心下痞硬”的症状没有完全好，或者说有余症。所以，他觉得还有心下痞硬，还应该再下，他才用这个“下”。那么这样呢，要如果他下利好了的话，用这三个泻心汤之一的可能性就比较大；用大黄黄连泻心汤的可能性就非常小。那么这儿还有一个问题啊？既然“心下痞硬”是泻心汤的方证之一，而且服了泻心汤以后，下利的症状也基本上好了，为什么“心下痞硬”反倒不好呢？在第 156 条里面有所论述。那个条文咱们学习的时候曾经说了，“胸满”也是条文里边的一个症状，“胸满而心下痞，与泻心汤痞不解，其人渴而口燥者，小便不利者，五苓散主之”。实际上是有

停饮，停饮造成的心下痞。那么服半夏泻心汤、生姜泻心汤或甘草泻心汤是治不了的。所以这儿应该是包含了这么一层意思。

下边“复以他药下之，利不止，医以理中与之，利益甚”。这个“他药”在其他的地方，像丸药什么之类的，是指的巴豆剂之类的温性的泻下方剂。之所以再给下，是因为还有“心下痞硬”，所以才给用了泻下药。这个时候又造成了下利不止，这个“下利不止”已经是屡经误下之后，形成的肠道虚衰性的滑脱，不是里虚寒的下利。所以，当医生误诊为里虚寒下利的时候，就给了理中汤。但是吃了理中汤以后，反倒是“利益甚”，就是下利更严重了。这个地方就佐证了前边这个“他药”，应该是温热性的泻下药。不然的话，如果是一种虚寒性的，用理中汤或者是四逆汤都可以的。即使是进入阴证，要是用理中汤的话，也不会下利更厉害，只要是里虚寒性的，用理中汤至少不会出现下利更严重。那个“白散方”的方后注里边，有一句话可以给我们启示：服了白散以后，“不利，进热粥一杯”；“利过不止”的，“进冷粥一杯”。温下的药，如果嫌药力不够，还没有出现下利的，就给喝一杯热粥；如果下利太厉害的话，喝一杯冷粥。大家想想，热性的下利，如果用理中汤这类药的话，必然会出现下利更厉害的这种结果。

这个嵌注“理中者，理中焦，此利在下焦”，他认为理中汤是治胃部疾病的，对于肠道里边出现的下利，不能治。但是这种解释，有失片面，或者有偏差。关键的问题是什么啊？这个下利不是理中汤所主的，不是它能治得了的。因为它与理中汤适应证存在质的区别，有着“寒热”这个病理上本质的区别。即使是下焦出现的下利，只要是虚寒性的，用理中汤实际上也没有问题，也能治得了的。

那么后边的一部分注解：“复不止者，当利其小便”。就是说上述的情况，如果是因为里饮证所致，这个时候就不再是“赤石脂禹余粮汤”的治疗范畴了，那么应该用利小便的方法来治疗。《康平本》

和《宋本》上这个解释啊，还是比较客观的。没有给予具体的治疗方剂，要你再去辨证，只是给了一个原则。

本方证的病理就是一个里虚证。因为从这两味药一平一温来看，咱们就对这个方证，就不做寒热方面的定义了。这个方证在病理上可以说是比较特殊的。从条文论述来看，应该是属于“里虚热性”的下利。但是这个方中的药物，却没有一味寒性药。所以这个方证，应该是以肠道功能虚衰为主要的一个里虚证。长期下利之后肠道机能，有这么一种滑脱不收，虚惫放弃的这么一种被动的表现。像习惯性的下利，而且下利不止，不能自收；再一个就是肠道松弛滑脱这一类的症情，常在这个方剂里面出现。离了赤石脂、禹余粮这两味药，这一类的下利治不了。什么寒热这方面有点偏差，就有点偏差吧，只要是能把病治了。

下面做个小结：

伤寒病服泻下药后，出现下利不止、心下痞硬，服泻心汤类方剂后，下利得止，但心下痞仍有余证。医者见此又以巴豆类方剂泻下，再度出现下利不止。医者再以理中汤治其下利，但服药后下利反而加重，此为赤石脂禹余粮汤主治之证。如果本方仍不能治愈者，则可能为里饮所致，可用利小便的方法治疗。

这个方剂呢就两味药，赤石脂，太一禹余粮。赤石脂性偏温，禹余粮是平性的药，这两个药都是固涩性的药物。

那么下边看看方证：

症状：下利、体型消瘦、便秘、面色苍白。

舌质：淡、红、绛、燥。

舌苔：白、薄、黄、腻、干。

脉象：细、濡、数、虚、沉、弦、滑、涩、浮、弱。

现代疾病：肠壁糜烂、肠伤寒并发肠道出血、溃疡性结肠炎、崩中漏下、带下、脱肛、慢性肠炎、过敏性肠炎、慢性非特异性溃疡性

结肠炎、慢性痢疾、消化不良之下利滑脱、子宫脱垂、滑胎。

伤寒吐下后、发汗、虚烦、脉甚微、八九日心下痞硬、
胁下痛，气上冲咽喉、眩冒、经脉动惕者、久而成痿、（160）

胡希恕：这段是承上面 67 条，伤寒若吐若下后，心下逆满气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白术甘草汤主之。前面是脉沉紧，此为脉甚微，此说明太阳伤寒应发汗，无论吐或下为误治，如表不解则气上冲，气上冲则里饮伴气上冲往上来，故心下逆满气上冲胸起则头眩，脉沉紧，都是水挟气往上冲表不解的关系，此时更不能发汗，前面讲了，如果里面饮气发作，其饮上于心下，心下有水气表不解，非利水不可，再发汗动其经脉身为振振摇。此段伤寒吐下之后，表不解，下面的症状发现了，起码是气上冲（表不解嘛），没有水还好，但此人素有饮，饮必伴气上冲而逆于上，就是心下逆满气上冲胸，水往上，则头晕，所以起则头眩，可是脉沉紧，吃苓桂术甘汤就好了，桂枝甘草解表治气上冲，再加利尿药就是苓桂术甘汤，表里都好了，可又发汗，“伤寒吐下后发汗”，是接

67 条说明，吐下虚其里，汗又虚其外，所以这个人虚热不退还烦，表不解嘛，不去水则表不解，可是脉甚微。吐下发汗皆伤人体液，所以脉微是亡阳，亡阳是亡津液，“八九日”，由吐下，又发汗，八九天后，心下痞硬，不是心下逆满，是虚的厉害了，发汗也虚胃，胃虚客气往上来，所以他痞硬。客气就是水，胁下痛是冲气和水往上攻的厉害，气上冲咽喉，不仅气上冲胸，还冲咽喉，比 64 条更重了。眩冒为水上冲所致，冒为头重，眩为晕眩，经脉动惕者，经脉跳动，久而成痿。可见水饮危害相当重，如治疗不当，就可能久而成痿。这个病怎么治疗呢？如果没陷入纯阴证，还可用苓桂术甘汤，如果陷入阴证，用真武汤类，看具体情况。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边是降一字格排版的条文。

咱们解读一下：

这个条文里边是病因病症俱全，但是却没有给具体的治疗方法。他为什么不给治疗方法？他的用意是什么？在《伤寒论》这本书里边，有若干个条文论述的，某些疾病看起来症状反应明显，但是它却是由于人体处于恢复期，所表现出来的一些正常的生理反应，是短时间内出现的，可以自愈的那一类。所以就特别形成条文，来告诫读者，这一类的情況不要妄加治疗。最典型的条文就是第 59 条“大下之后，复发汗，小便不利者，亡津液故也。勿治之，得小便利，必自愈”。

“伤寒吐下后、发汗”，表证本来就应该是发汗的，但是他先吐、先下，这都属于误治；吐下以后，再给以发汗，《伤寒论》里边“发汗”就是指的麻黄汤之类的方剂。如果他存在表证，表证还没好，又没有里证的话，也得用桂枝汤，也不能用麻黄汤发汗了，这就等于说错上加错。

“虚烦、脉甚微”，类似于有点出现了阴证了。但是咱们学这个条文，没有必要非得具体到这是某一个方证。作者的本意也不是让你在这儿找到具体的治疗方法，只是给你说经过误治以后，对人体的损害比较严重，已经到了陷于阴证的这种程度了。

下边看“八九日心下痞硬，胁下痛，气上冲咽喉、眩冒、经脉动惕者”。

这儿的“八九日”应该理解为经过上述的误治以后，由于人体的抵抗力严重受损，所表现出来的症状反应反而没有很明显的那种急迫症。仅仅表现为“虚烦、脉甚微”，其他的也没有说有什么特别明显的那种急迫的症状。但是随着人体渐渐恢复，误治以后的变证就慢慢地凸显出来了。在八九天的时间，他表现出后边论述的诸多症状。

“心下痞硬、胁下痛”，就是胃功能虚弱而造成的胃中停饮，也就是说是人参证。而这里的“心下痞硬”，也不排除柴胡证的可能。

综合这些症状，更多是既有里饮，同时又有气上冲的因素存在，所以造成他胁下疼痛。

“气上冲咽喉、眩冒”，在病理上，比较接近苓桂术甘汤证的既有里饮、又有气逆，接近于那种病理状态。

“经脉动惕者”，就是由于人体机能沉衰，同时又有停饮，造成人体体表组织失养而表现出来的这么一种症状，类似于真武汤证。

“久而成痿”，这才是这个条文的关键处。他的本意是什么？告诫读者此类情况一定要及时地对证治疗。否则就会发生痿证。“痿证”是古代的一个病名，指的是四肢萎软无力，尤其是下肢颓废，甚至是肌肉萎缩的这么一种病。这是一个很严重的问题。所以说这个条文就告诫人们像这个一定要治，你不能不治。但是这个条文里边并没有给出具体的治疗方法，像这一类情况，一个是情况比较严重，也比较复杂。但是不管如何的复杂，不管怎么变化，都在经方的治疗范畴之内。所以你都得去根据具体的情况，按照经方的理论来辨证施治这病，就可以了。

伤寒发汗、若吐、若下、解后、心下痞硬、噫气不除者、
旋覆代赭汤主之、（161）

旋覆花三两 人参二两 生姜五两 代赭一两 甘草三两
炙 半夏半升洗 大枣十二枚擘

右七味、以水一斗、煮取六升、去滓、再煎取三升、温服一升，日三服、

胡希恕：太阳伤寒，经过发汗吐下，病好了，可是出现里虚的情况，心下痞硬胃虚了，这也由于吐下之后，大病之后胃气虚，气逆而为噯气不除，旋覆代赭汤主之，我们可以这样理解，此人素日胃就不

好，可没明显发作，由于外感，经服药，吐下等伤胃气，新得的病好了，但素日胃的疾患明显发作，心下痞硬，就是人参证了，为胃虚，邪饮趁胃虚而往胃上来，故心下痞硬，邪气上逆，故噯气不除，应用旋覆代赭汤主之。此方半夏泻心汤、甘草泻心汤、生姜泻心汤大有相似之处，也有人参、生姜、甘草、半夏、大枣，为健胃治逆的，治呕逆，另外加旋覆花代赭石，旋覆花是下气去结气的。代赭石是收敛性健胃药，此药在治本病不要重用，多用反伤胃，后世说是镇重使逆气不往上来，其实是收敛性的健胃药，有点补益的性质，此药重用，对胃不好，所以用人参、生姜、甘草、大枣、半夏，就是健胃降逆，用旋覆下气去结气，代赭有点健胃镇逆作用。此方与前三泻心比，没有芩连去热，也不解烦，也不治下利，此药在临床上对胃的疾患，经常有噯气不除，与生姜泻心汤噯气食臭，不同的是，有下利，而这里没有，反倒治大便干，对便秘，此方有效。旋覆代赭往下行的力量相当大，此方治胃疾之噯气与陈皮之噯气不同（橘枳姜汤，也治噯气），后者之噯气是，觉得闷打嗝后舒服，希望打嗝才好，为橘皮证，茯苓饮也有此证候，一般胃不好，食欲不振，有逆气，但打嗝较舒服，主要以痞闷为主，用茯苓饮就好，健胃行气利水，而旋覆代赭石不是的，它是苦于打嗝，噯气不除嘛，难受，故此方有治噎膈的机会，就是胃食道发炎，癌证等打嗝相当凶，用此方好。另胃泛酸，胃痛、打嗝、大便干，此方好使，如果酸太多，可加乌贼骨，注意大便稀不行，用茯苓饮比较好，这些都是常用的方，苦于噯气所以说“噯气不除”。

李冠杰：这个条文在《康平本》是顶格排版的条文。

下边解读一下：

“伤寒发汗，若吐、若下”。这一部分是条文里的病因。这儿历来容易出现的问题，常常把这类的论述具体化。比如像这条就可能解读成：本来就是伤寒，后来又经过发汗，又经过吐，又经过了下。实际上作者的本意不应该是这样的，我们把这一段文字要当作一个整体

来解读，而且把它模糊地来解读，不要精确地说它一定是一个具体的医案，不是医生对一个患了表证的人先发了汗，然后又吐、又下，实际上这样的也非常少。我们可以这么理解：对表证或者是用了发汗的方法，或者是用了涌吐的方法，或者是用了泻下的方法。

这儿就有一个问题，伤寒发汗，这是正治，应该发汗。但是如果整体解读，它可能本身就可以形成病因的条件。伤寒发汗以后，为什么还会出现变证呢？这有几种可能：比如方和证不是对应的那么恰好，这是其一；另外方证基本相应，但是护理的不当，致使人出汗过多，也可能会出现变证。若吐、若下，对表证来说无论是吐法还是下法，都是误治。所有这些结果，汗也好、吐也好、下也好，这都是一些攻法，如果应用不当都有可能造成不良的后果。这里讨论的就是出现了相对比较特殊的一种方证——“旋复代赭汤证”。

后边“解后”。从字面上来理解，就是表证得解之后。但是要严格地来分析，应该是指表证的症状反应消失。这种解表跟正常情况下，比如麻黄汤证，服了麻黄汤后，护理也非常得当，微似有汗出表解的那种情况，是完全不同的两种概念。就以这条文为例，如果对一个表证的患者施以下法或吐法，结果他反倒是表证消失了，但是出现了“噫气不除”，就是说出现了里虚寒的情况。表证的消失，没有经过合理地治疗，不是一种正常的表解。古人论述这类的解表，解释病理的情况非常得少，或者说那个时候也很难认识到这个层面。但现在看，这样的解表在《伤寒论》里很多，最典型的就是第 58 条，表证的解除，实际上是人体出现了里虚了，这时疾病的矛盾就集中在里证上，它就是里不足了，人体就没有在表证阶段抗病的能力了，所以说表证也就消失了。

这个有点像什么呀？我有时候跟一些人聊中医，聊的稍深一点他不懂，你就不能再说那么深，我就打这样的比方：比如像一个县城，公安都在县城里边，每天开着警车巡逻，晚上也有巡逻的，县城里的

治安就会比较好一些。但是到乡镇上仅仅有一个派出所，几十个村子就靠派出所五六个人，它管理的面积又大，人也复杂，治安情况相对就不如城里好，往往容易出一些事。但是假设城里乱了，这时候就把派出所的人都抽调到城里来帮着搞治安，本身乡镇就比较薄弱，再把所有的人都抽调上来，或者抽一半人，反正它的力量削弱了，甚至就比以前更乱了。人体它也有这类的功能，当它的疾病矛盾集中在里部的时候，往往有时就会放弃从表这个阶段抗病的能力，然后表证就消失了。

现在的孩子从生下来的第一天开始，只要是感冒了就开始进入这种境界。特别现在孩子吃中药根本也吃不下去，也不好辨证，现在能看儿科疾病的越来越少，慢慢就去找西医治，西医比较好的办法就是输液，现在一些小医院里，没有任何人给你解释对于感冒现代医学处于什么状态，它没有有效的治疗办法，说到底就是治不了。所有治疗感冒的这些手段，都是缓解感冒症状，只是让症状消失了，从疾病的机理上它对感冒病毒一点办法都没有。感冒病毒是在细胞里自我复制，目前全人类也没有找到能够杀死细胞里病毒的药物，没有有效药物，实际上是治不了。但是输了液以后，确实感冒症状消失了，有的还特别快。怎么消失的？这等于就是误治嘛，抗生素可以降低人的抵抗力，实际上是人为的造成里证，让人体的能量全都集中到里边去对抗这个抗生素的副作用，把在表证阶段抗病的能力给抽回去了，表证就消失了。现在的孩子，百分之八九十全是在这种情况下治感冒，都是这么治好的。让孩子再恢复一段时间他又感冒发烧了，还得去输液，这几乎成了在用现代医学的药物不断地去测试人体的耐药力有多强。实际上中医里观察到这个现象，道理是一样的，就是出现了这种情况，表证消失了。这个地方说的“表解”，实际是这个层面上的表解。

学习中医理解透了这个，在临床当中就会去理解亚健康的人。现在常有这样的人，比如平时精神不好，睡觉也不好，也没力气，也不

愿意吃饭，看着平常还行，好几年都不怎么感冒。实际上他是没有能力感冒，只要能让他的健康水平往上再抬高一点，破坏这种亚健康的平衡，他马上就感冒了。

前两天我碰到一个病人，是一个学校的副校长，长期饮酒，几乎每天饮酒。他就这么说：我很少得病，很少感冒。摸摸他的脉，差不多摸不到，脉细欲绝，又沉又细，包括脸色好多地方不好。我就给他弄了药吃，吃了大概有十来天，他就感冒了，以前感冒输上两三天的液就好了，这次的感冒一下输了四五天。他后来见了我，说还没有彻底好。实际上我们心里明白是怎么回事，跟他说他也明白，但是他不能真正地接受。

经过上边这些误治，虽然表证的症状消失了，但是却出现了“心下痞硬，噫气不除”的变证。这儿的“心下痞硬”，与我们学过的三个泻心汤（半夏泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤）的“心下痞硬”，无论是病理状态上，还是症状反应上都比较类似，基本上就是属于一种类型的疾病。它的病理就是“里虚寒”所致的胃肠功能的低下。

“噫气不除”是这个方剂的一个特征性的症状反应。在我们病理辨证里属于典型的气逆证，是因为里虚寒造成的一种气逆证。

“里虚寒”可以造成的里证情况很多：比如理中汤会出现下利，但是很少会出现“噫气不除”的情况。虽然说病理相似，但是造成的症状反应不一样。实际上在同一个病理状态下，也存在着质的不同，等于说胃肠里边的状态相差得挺远，但是它们总的病理状态都是里虚寒。因为“噫气不除”是方证的特征性症状反应，所以正确地理解“噫气不除”的含意，对用好这个方剂有比较重要的意义。

这个“噫气”具体到旋复代赭汤方证，临床中大致有这么两种表现：

一种类似于生姜泻心汤证的“干噫食臭”，就是胃中有气往上逆，从嘴里噫出来以后还有声。区别在于本方证的“噫气”没有食臭的味

道，没有生食味、不消化的味道；而且这个“噎气”的特点是噎气以后胃里依然不舒服，表现为一种持续性的胃中不适感，所以称它“噎气不除”，就是越噎气越难受，希望这个气别再上来。临床中有的病人会这么说：我咯完气以后，胃里觉得还有气往上来，还得咯，实际上就比较接近这种方证了。为什么突出强调这个症状？因为《金匱要略》里有橘枳姜汤证和茯苓饮证，都有可能出现噎气的情况。但是那两个方证的噎气有一个很重要的特点，就是噎完气以后病人主观感觉胃里舒服。这个“噎气”是本方证的一个特点，跟别的方剂可以鉴别的。

第二种就是俗称的打嗝，打嗝和噎气如果从文字上不太好描述。在书上常常弄混了，特别是初学的老弄不清什么算噎气，什么算打嗝。打嗝是一种俗称，用文字描述应该叫呃逆，是一种病症名，中医认为是胃气上逆，但是现代医学研究这样的症状都有膈肌痉挛，或者是胃痉挛的因素存在。也就是说这个方剂又可以治呃逆，也可以治暖气，两种它都可以治。治打嗝也有其他的方证可以给它做鉴别的，比如芍药甘草汤证。芍药甘草汤证里有时候会出现打嗝的情况，那纯属肌肉组织痉挛、膈肌痉挛、胃痉挛这一类的。它跟旋覆代赭汤证的打嗝有什么区别呢？它是以痉挛性的呃逆为主要特征的，旋覆代赭汤治的常常伴有气往上来，芍药甘草汤治的那种气往上来的趋势不重，它往往都是一些意外的原因引发的阵发性的打嗝。像那类的打嗝，生活中常常都有一些小窍门来治：有时候连喝几口热水能缓解或者治疗了；有时候深吸一口气，往里吸气吸到不能再吸了，然后憋住，一直到憋不住了再慢慢地把气呼出来，轻的时候也能治；还有时候用精神方面的刺激，在打嗝的人不知道的情况下突然吓他一跳，制造点特殊的声音或者意外地打他一下，有时候也能好，还有的把人指甲绞了以后用火点着了，用气熏一熏也能好。但是严重了以后这些办法都不会太有效。像这里的大部分都是胃虚，里虚寒不太严重，主要是痉挛，芍药甘草

汤有应用的机会。

我们说到这里了就出个岔。从这个地方我们能看出人体的内环境平衡非常微妙。就以芍药甘草汤为例，这个方证所治的打嗝，是什么机理呀？这个肌肉之所以痉挛，是因为血虚造成肌肉缺乏某种营养，它才出现痉挛的情况。方剂里的芍药肯定可以治这个，大量的甘草也可以治一点里虚，甘草有补里虚的功能，因为它也存在某种程度的里虚。但是这个人突然喝了几口凉水，或者喝了一点啤酒就造成打嗝了，实际上他在这种疾病的边缘上或许已经较长时间了，肌肉组织里一直就有因为血虚造成的营养缺乏，一直有这种状态。一旦有了外界因素的干扰、诱导，一下子打嗝就发生了。打嗝严重的有打好几年的。不说用药治，就像吓一跳、喝几口热水能好的，大家想想这样的平衡多么微妙啊，就是用外界的因素干预了人体的内部平衡，有时候就足以消除这种症状，这说明人体内环境的平衡非常非常地微妙。而且如果用的方法对了，见效也非常地快。这就印证了为什么经方只要是方证相应，治病效如桴鼓，道理就在这里。咱们说的是这个方证里比较典型的一个症状，也不是说所有的患旋覆代赭汤证的人都有或噎气、或呃逆这类的症状。

旋覆代赭汤证的病理就是里虚寒证合并气逆证。

做个小结：伤寒病如果经发汗，或是涌吐，或是泻下的方法治疗之后，表证消失，但是却出现了心下痞硬，噎气不除的症状，为旋覆代赭汤主治之证。

这个方剂在临床中是一个常用的方剂，用好了可以治很多病。这个方剂由七味药组成：旋覆花、人参、生姜、代赭石、甘草、半夏、大枣。从药物的药性来分析，可以把这个方剂分成两部分：一部分是人参、生姜、甘草、半夏、大枣，这五味药可以看做一个方子，有温中，祛饮，健胃，补虚的功能，它的作用就跟半夏泻心汤把黄芩，黄连去了差不多。这明显地能看出这个方证没有半表半里的热证，没有

热象，纯是一个里虚寒证。旋覆花、代赭石是这个方剂的另一部分，是方的主药，它治方证的特征性症状。其中旋覆花是一味温性的药，具有消痰下气、软坚行水的功能。现代研究认为这个药可以缓解机体某些组织痉挛和强化胃肠蠕动功能的作用。这个地方它有跟芍药甘草汤相交错的一个药理上的作用，芍药治血虚而见痉挛的，旋覆花也有类似的功能。代赭石按中医的理论认为可以补血。所以这个方剂所治疗的就是在里虚寒证的基础上又出现了痉挛的情况，这就佐证了现代医学研究的打嗝是膈肌痉挛、胃痉挛这类的情况，能跟经方的治疗接轨，这个地方是能吻合起来的，参考意义比较大了。但是现代研究旋覆花利尿的效果不明显，当然在经方里很少看到用旋覆花来利尿的，我觉得中医对它利尿的功能或许是总结的名不副实。代赭石是平性的，寒热倾向不明显，它有镇逆、凉血、止血的作用，有的说它可以治疗血虚，因为代赭石从颜色上看是红色的，颜色还挺重。因为我现在都是做粉剂，代赭石在这个方剂里用的量非常小，比其他的药量都小，而且这个药质地非常重，比重很大，我做药的时候，常常把一两折算成一克，像这味药有时候用到一克，甚至用到0.5克那么一点儿，粉碎了以后整个一剂药全都是红色。现代医学研究它能够收敛胃肠壁，能够保护胃粘膜，促进血细胞的新生。但是我觉得现代研究常常带有一定的片面性。在临床实践过程中，胡老明确说了这个药用的量不能太大了，大了反倒是对胃不好。那么要如果按照现代科学研究的它能保护胃粘膜的功能，又能促进细胞生长，用的量大了那不挺好嘛！但实际真用得多了还不行。

同时，这个药跟旋覆花有一个功能非常相似：它能促进胃肠的蠕动功能。这两味药都有促进胃肠蠕动的功能，方剂里虽然有一些生姜，用生姜的量比较大，像半夏、人参这些药对肠胃都非常有好处。但是有了这两味药以后，它就有一些缓下的作用，这个缓下跟大黄之类的泻下不一样，它没有那么大的力量，它能兴奋人体胃肠的蠕动，使得

肠道消化道里的食物运化得比较快，所以对便秘比较有好处。如果便溏厉害的，甚至下利的就得注意了，肯定就不能用了。略微有点偏溏的问题不大，也可以用。

这个方剂我前段时间还用过一次，山东高唐县的一个病人，他一是暖气这个典型的症状，另一个症状就是感觉肚子里有气，敲敲还“嘤嘤”地响，腹部也看着有点大，他说比前几天的症状已经轻了。但是暖气挺明显，而且暖完气后还挺难受。我就把这个方剂和厚朴生姜半夏甘草人参汤合到一块儿给他。到了第三天，他给我打电话说：这个药是不是有泻下的作用啊？我吃了药以后大便有点稀。我问他那些症状怎么样啊？他说好了，吃下去很舒服，但就是一天大便解两次，而且还有点偏稀。我问他解完大便以后有没有浑身没劲，就像拉肚子？他说没有，倒是挺舒服。我告诉他如果症状消失，就可以不吃药了。这样过了一段时间，一直都没事。

虽然从药物组成上看，这个方剂与半夏泻心汤类方比较接近，但是临床上也有明显的区别的：因为这个方剂里没有祛热的药，如果有热象就肯定不太适合这个方证；另外，半夏泻心汤那类的方剂，都有因为寒热错杂造成的肠鸣，这个方证出现肠鸣的机会就不多。

这个方子跟理中汤如果比较一下，在病理上都是里虚寒证，理中汤没有气逆，它就多一个气逆。但是从症状上看，区别就在于一个是有气逆，一个没有气逆；一个有暖气，一个没有暖气，或者说打嗝。但是从疾病病理的深层次，它这个病到底胃肠里有什么样的变化？发生了什么样的病理改变？这两个方证之间有什么样的不同？恐怕现代医学也很难给出答案，因为现代医学不研究这个。这两个症状之间的区别不太好说，现在没有一个比较恰当的说法。咱们学厚朴生姜半夏甘草人参汤的时候，曾经说过这类的情况，我们可以把它理解成消化道里，特别是胃里边比如菌群的失调，或者是胃的内环境发生了病理改变。这两个方证，胃的内环境虽然都是里虚寒，但是不太一样。

要是这样，这个方证哪来这么多的气体啊？像这个方证严重的，患者来看病的时候就不停地在暖气，甚至有时候他主诉都说不成，因为暖气不得不中断说话，挺严重。这些气体哪来的？非常值得研究。现在只能借助于现代科学的一些手段，才能慢慢地研究清楚。但是作为中医，研究清楚是这样治病，研究不清楚，我们依然是这样治病，而且疗效特别好。

下边看看这个方剂的方证。先看看症状，从出现频率最高的，到出现频率最低的，依次往下降。

症状：恶心、呕吐、食欲不振、脘腹胀满（这都是里虚寒的一些典型的症状）、便秘（这个便秘既不是津液虚，也不是有里热，这个便秘是因为胃肠蠕动功能差，肠道里边的食物就运化下去得慢，非常慢造成的）、呃逆、暖气、眩晕、便溏（这儿还有可能出现便溏呢！但是这个便溏说得比较有分寸，不应该是腹泻，绝对不能是痢疾之类的，就是大概大便偏软一些、稍微有一些偏溏，也有可能出现的，这也是里虚寒造成的）、咽喉异物感（你看这个方剂还能出现这一类的症状呢）、精神抑郁、神疲乏力（这个咽喉异物感、精神抑郁，其实有些精神方面的因素，半夏厚朴汤它也有这类的症状，看这些药物都跟胃肠有关系，但是它常常同时伴有一些精神方面的一些症状，说明这跟精神方面关系比较密切，影响到了精神方面）、胸闷、胃脘痛、形体消瘦、畏寒肢冷、尿黄赤（这个尿黄赤，本身是一个典型的里虚寒的病，出现了小便像是有热象，是不是存在另外的原因啊？一是可能因为里虚寒，胃肠功能差，津液吸收的少，身上的水分相对地说代谢量就少，可是人体的正常代谢功能得行使，也就是在整个代谢过程中进去的新水少，出来的旧水也少，导致尿的浓度就大；另外一个，就是说在辨证的过程中，因为咱们这些统计资料里常常都有加减，是不是误把既有里虚寒，又有寒热错杂的这类的情况也用这个方子治了，加了一些祛热的药，这也有可能的）、腹痛、失眠。

舌象：以淡舌为主，淡舌，淡胖舌，淡红舌；红舌就比较少一些，有尖红，有红舌，还有绛红的。

舌苔：舌苔是以白苔为主，包括了薄白、白厚、白腻、白浊、白滑、白润；黄苔比较少一些，但是这里边也包括了有黄苔，有淡黄，有黄腻，有黄厚苔；还有少量的无苔、灰苔，无苔的比灰苔的要多一些，出现无苔很容易理解，因为它是一个虚证。

脉象：弦脉最多，其次是细脉、滑脉、沉脉；数量更少的，就是缓脉、弱脉、濡脉、紧脉、实脉、迟脉、数脉。

在旋复代赭汤证的病理状态下，可能出现的现代疾病，就是临床中用这个方剂有治愈记录的现代疾病：主要的以消化道的疾病比较多，像食道痉挛、食道弛缓症、食道癌、食道癌术后并发症、食道炎、食道梗阻、贲门痉挛、幽门痉挛、幽门梗阻、胃痉挛、胃溃疡、膈肌痉挛、胃扭转、胃下垂、胃扩张、瀑布状胃、胃癌、急慢性胃炎、浅表性胃炎、胆汁反流性胃炎、胃及十二指肠溃疡、十二指肠应激症、胃肠神经官能症、不全肠梗阻、急慢性胆囊炎、肝炎、阻塞性黄疸、肝硬化、肝癌、美尼尔氏综合征、神经官能症、癔病、失眠、头痛、脑膜炎后遗症、神经性呕吐、癔症球、中风、呃逆、脑动脉硬化、脑血管痉挛、脑震荡、脑脓肿、脑血管意外、急慢性支气管炎、支气管扩张、哮喘、肺气肿、肺心病、支气管结石症、百日咳、肺结核、高血压病、高血压性心脏病、冠心病、心肌梗塞、阵发性心动过速、心绞痛、慢性肾炎、肾病综合症、尿毒症、妊娠恶阻、月经不调、子眩、不全流产、产后恶露淋漓不尽、视畸（视畸就是像复视或者是视物倒转）。

大家看这个方证治疗过的现代疾病，有一些是我们想不到的疾病，比如一些精神方面的病，还有一些妇科里的病，还有一些脑血管方面的病，甚至包括最后这个看东西重影，叫复视嘛，或者说视物倒转，那就很奇特，这类的情况我们见到得很少，但是有用这个方剂的

机会。这说明人体在里虚寒比较重的情况下，形成了这种气逆证之后，它影响的范围比较宽，出现的疾病也比较特殊。我们如果能够把这个方剂理解得比较深、比较好，临床中可以处理一些很棘手的、很奇特的病。

喘家^①、下后、不可更行桂枝汤、若汗出而喘、无大热者、可与麻黄杏子甘草石膏汤、^②（162）

注：

1. 《宋本》无“喘家”二字。
2. 《宋本》此处有麻黄杏子甘草石膏汤方及方后注，此从略。

胡希恕：下之后表不解，一般说应该用桂枝汤，但有些例外，尤其在此与桂枝汤有些相反，桂枝汤加厚朴杏子，也治汗出而喘，喘也是气上冲的反应，但这里不是的，这里是里有热而汗出，表不解，故还喘，有麻黄证之喘，但麻黄汤是不汗出，里有热阳明法多汗，热壅于里，蒸汗于外。所以不能用桂枝汤，因里热不能用桂枝，所以麻黄汤把桂枝去了，加去热之石膏，前面讲了麻黄配石膏反能治汗出，麻黄配桂枝必能出汗，而且桂枝不利于里热，所以不能用桂枝加厚朴杏子汤，故说“不可更行桂枝汤”，“无大热”，阳明病里头大热，蒸蒸发热，如果是此种发热麻杏石甘汤就不行了。虽然有里热，但不到阳明病的程度。这与桂枝汤的汗出不一样，这里汗较多，且味重，桂枝汤证的汗少，稀薄无气味。故治喘，如果有热，给石膏比较好。在肺炎初期可用，但不能频繁用，只要符合这种情况，汗出而喘才可用，仍要辨证，小儿多。没有汗也可用。我给我儿子开此汤，那时他只有4岁，出疹子，我不在家，他奶奶给吃牛黄丸，那药太凉了，当我回来的时候疹子回了，喘而无汗，脸红昏迷不醒，很危险，他舅舅正学医……嘿，来了开了方子我不同意，全是一种还是解表、祛热、解毒，

这种套方，我说不行吧，等客人走了，我跟他舅舅商量，我说就吃麻杏石甘汤，……就开这个，开这个哪，石膏用得少，麻黄用得多一点，他吃了，慢慢的脑袋见汗了，就吃这个，后来没再吃药就好了，他那也是……并发肺炎，你看这个好了之后，他舅舅说的，哎呀，咱俩这……，他没有汗用这个行吗？我说没关系，石膏清热不一定有汗，这是我头一开始给人家开方子，还是给我儿子，那时我才二十六七岁，我的孩子四岁。

李冠杰：这是降一字格排版的条文。

《宋本》里边没有“喘家”这两个字，这也挺有意思，在学习的过程当中咱们会讨论。再一个就是《宋本》在这个条文之后，附有麻杏石甘汤的方和方后注，《康平本》当中没有。

这个条文的内容咱们一读啊，大家都知道，就是说凡是学《伤寒论》的，因为《伤寒论》就需要前后条文对照着来读嘛。这个条文和《伤寒论》里边第 63 条条文的内容，基本是一样的。第 63 条就是前边几个字有点不同，也就是说病因不太一样。63 条是“发汗后，喘家不可更行桂枝汤，汗出而喘，无大热者，可与麻杏石甘汤”。不同的是什么呀？一个是“喘家下后”发生麻杏石甘汤证，就是这儿。第 63 条是“发汗后喘家”，是喘家发汗后。如果我们从经方理论重证、不重病因的这个角度来看的话，这个条文和第 63 条就没有什么区别。不管是“下后”也好，还是“发汗后”也好，只要是出现这个方证，就应该用这个方子来治。既然是这样的话，为什么这个条文又重新出现呢？实际上，咱们如果前后条文对照着来解读的话，你就会发现他有一定的道理的。如果从字面上来理解第 63 条和这个条文，可以这么理解，就是他想说泻下后和发汗后都可能造成、可能出现麻杏石甘汤证，就是这么一个意思。这是一个最浅层次地理解，应该理解到这个层面。

如果细推敲的话，这里边就有一些挺有意思的事儿啊。大家看看

是不是有道理？第一个就是这两个条文在《康平本》里边，你会发现都是降一字格排版的条文。而且这两个条文呢，它所论述的是同一个方证，而且文字也几乎相同。首先，第一个可能性就是这个条文的作者，也就是降一字格排版的这个条文的作者，他是根据自己的临床经验总结所得，他觉得这个事儿挺重要，有必要强调，这是我们首先应该想到的。第二个呢，这两个条文所论述的内容，除了病因之外，几乎完全都一样，文字都几乎一字不差，这在古人这个经典的著作当中，特别是咱在《康平本》里边看到这是出自一人之手，都是降一字格排版的嘛，像这一类的情况是非常罕见、非常少。几乎是相同的文字，那么两个条文放在一块，要如果说不在同一本书上还情有可原。在同一本书上，像那个时候惜墨如金的那个年代出现这种情况，非常罕见。

再借助于其它的条文，咱们来看看这是一个什么样的问题？第149条是一个顶格的条文，149条开头的前半部分“伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具”，有这么几句话。而在这本书的后边第379条有这样的论述：“呕而发热者，小柴胡汤主之”。但是这个“呕而发热者，小柴胡汤主之”，是降一字格排版的一个条文。这很明显，就是降一字格排版的条文，把顶格排版的第149条里边的一句话摘出来了放在这儿，作为一个单独的条文对小柴胡汤证做了一个专门地论述。咱们要这么去理解，这个书上有这样类似的条文。我们再反过来看看第63条和这个条文，仅仅是病因不同，一个发汗，一个下后，这就存在着另一个可能性，这两个条文有可能其中一个条文，原来的时候是顶格排版的。这个降一字格排版的作者，觉得另外的原因也能造成这个方证，就把这个条文又改了一下病因，放在这个地方了。但是在抄写的过程当中，可能都给弄成降一字格排版的条文了。这个抄写的过程有时候就一字之差，就是起头的时候位置不同。

但是这个咱们得客观地看，这只是一种猜想。客观地看，古人抄东西的时候，这个东西很不容易抄错。因为那个时候古人抄啊，他数

字的这一行 23 个字，你抄的这一行的最后一定得是跟原书字是一样的。要不一样的话，就有可能这一行里少一个字或多一个字，那么他起行要起错了，他马上就能发现，这也是一个客观事实。咱们不妨就这么想一想，因为太奇特了。两个条文几乎完全一样，像这么经典，这种经文里边出现这种情况，不得不让人这么想。

另外关于这个“喘家”。《康平本》里边，这两条都有“喘家”这两个字。但是到了《宋本》里边都没有，都给删除了。这儿肯定不是一个偶然的遗漏，不可能这么巧合。那就只有一种可能性，就是王叔和在第二次整理这本书的时候，把它删掉了。为什么要删呢？大家其实看一看内容会有这样的感觉，因为这个条文里边有“汗出而喘”，既然本身这个证里边就有喘，他前边是不是喘家，就不太重要了。把“喘家”删掉了是不是出于这方面的考虑，这也不好说。但是原文里边这个“喘家”有一个很重要的作用，就是说了“不可更行桂枝汤”，这儿让你与桂枝加厚朴杏子汤鉴别。因为桂枝加厚朴杏子汤有喘家作，这样要联系起来的话，“喘家”这两个字还是挺重要的。另外它本身也就是说平时素有喘的人，如果经过了误治以后，喘病会加重，也有这方面的意思。

咱们做个小结：素有喘疾的患者，发汗（泻下）后不适宜用桂枝类方剂治疗。如果其症状反应表现为汗出而喘，而且无大热的，可用麻黄杏子甘草石膏汤治疗。

大阳病、外证未除、而数下之、遂协热、而利^①下不止、心下痞硬、表里不解者、桂枝人参汤主之、（163）

注：“遂协热、而利下不止”《宋本》作“遂协热而利，利下不止”。

桂枝四两别切 甘草四两炙 白术三两 人参三两 干姜三两

右五味、以水九升、先煮四味、取五升、内桂、更煮取三升、去滓、温服一升、（注）日再夜一服。

胡希恕：太阳病外证未除，当然这也是指发汗药了，但是脉还浮，应该继续用桂枝呀，外证使用桂枝是这么说的，外证还没拉倒而数下之，连续给吃泻药，所以协热而利，使这个邪热陷于里，协同泻药而为热利以下，而为协热利，利下不止，心下痞硬，这个数下……所以心下痞硬，心下痞硬就是胃虚了，表里不解者，太阳病外证本来未解，三番二次给吃泻药，一方面得协热利，一方面表也没解，桂枝人参汤主之，就是现在所说了人参理中了，以人参汤理其中，也是胃虚衰了，那么以桂枝甘草汤而解其外，他这个桂枝人参汤就是桂枝甘草汤与理中汤的合方，你们看看对这个人参治心下痞这个就看出来了，那么这个方子心下痞硬就是人参汤，所以他是治胃，我们用人参啦，总得在这里头看这个药物的应用你才明白，所以人参不是万能，它是治虚，但是在胃有胃气虚而又有心下痞硬的这么种情况用它是最好的，所以古人就在这时用，你看看半夏泻心汤，甘草泻心汤，生姜泻心汤，旋覆代赭石汤，你这个你都看出来了，那么这个理中汤呀，主要的是胃虚心下痞硬，人或者有呕呀，大便稀呀，它由于胃虚造成的，那么这个协热利，这个利下不止应用这个理中汤是健胃治下利，用桂枝甘草汤呢解外。

李冠杰：这个条文呢，在《康平本》是一个顶格排版的条文。

条文当中“遂协热而利下不止”，在《宋本》里边给改成了“遂协热而利，利下不止”。

下边呢，我们解读一下：

“太阳病，外证未除，而数下之”，在表证存在的情况下，无论是有里证也好，还是没有里证也好，使用下法都是不对的。所以说这儿的“下之”就肯定是误治。“而数下之”，说明误治还比较严重了，下了还不是一次，其结果必然易发生变证。

“遂协热而利下不止”，这一段文字我们现在解读，应该把它做一个整句来读。《康平本》就在“遂协热”之后加了一个顿号。《康平本》加的这个标点加得挺有意思。既方便后人读，还保持了这个古书的原貌。但是到了《宋本》当中，成了“遂协热而利，下不止”。这个“下不止”从字面上看就不太通顺了，所以又加了一个“利”字。

这儿呢，涉及到“协热利”的问题。咱们前边在学习 139 条的时候，曾经做过讨论。因为涉及的问题比较重要，所以借着这个条文，再来审视审视“协热利”的真正的含义应该是什么？有关“协热利”的论述，在《伤寒论》里边一共有三处：除了现在学习的第 163 条之外，还有第 139 条和 258 条。其中的第 139 条是顶格的条文，而第 258 条是降两字格的条文。但是同样论述到了“协热利”。只有现在学习的条文这一个地方，有对应的方剂。所以说理解这个条文里边的“协热利”，意义就显得非常重要了。

那么，“协热利”的本义呢？应该有两种解释：一种，就是这个条文和第 139 条论述的意思，就是顶格的这两条条文。古人认为，这种下利是由于表证的热内陷与里证的下利合并，所以就称为“协热利”。但是，第 258 条里边论述的，是热性下利，不是寒性下利，那是另一回事。也是另一个作者写的，作为参照的价值就不高了。

对于这个条文里边的“遂协热而利下不止”，今天解读，咱就要重新认识它。因为这儿可以延伸出许多重要的基本概念。这个“协热利”在条文中的本义，是表证经过数下以后，表热内陷而发生下利。这儿有一个基本概念，咱们必须得闹清了。就是什么啊？表证的寒热。

我们讨论表证的寒热，其他的里证也有寒热，半表半里证应该也有寒热。咱们看看这个寒热是什么？它是一个病理的概念，指的是人体体内温度变化所反映出来的，这个话怎么说？实际上就是某些症状反应反映的是人体内部温度变化。说具体的吧，热指的是什么？实际上是反映体内温度偏高的症状的一个总称。比如：舌苔发黄、脉又浮

又数、脉洪大，包括流黄涕、面色潮红等等，就说热象有很多症状。

实质上热象的这些症状，都是在人体机能偏于亢奋，致使体内的整体循环加快。就跟汽车怠速调得特别高一样，车在那儿不动，但是机器的转速特高，两三千转，呼呼地在那儿转。不单单车磨损大，而且产生的热量也大。人体也是这样，脉跳得快，脉跳得快了以后血液循环就快，血液循环快消耗得就多，然后产生的热也多。就算是寒热错杂的情况，也不能改变这个事实。只要有热证，热证本身就是这一类的东西。

在临床当中或生活当中，有的人，天特别冷，但是穿得很少，明显比别人穿的薄。像这样的人，除了特殊情况以外，一般的都是有热。他产生的热量高，他还需要散热呢，所以说他不怕冷，他怕热，这是一种情况。另外还有里寒严重的人，做腹诊的时候，摸着他的胃部或者小肚子这地方，你能感觉到凉。其体表部分温度都低，你想想体内温度还能不低吗？最终说的还是体内温度低。当然温度低有温度低的机理，温度高也有温度高的机理，机理是一回事，但是最终还是说的“体内温度”的问题。

那么表证的寒热应该是什么呢？表证的寒热就应该是指体温了。但是，要如果这么定义的话，那么阳性表证里边（咱以阳性表证为例子），就不存在寒的问题了。为什么不存在表寒的问题？因为这个发热是表证的一个基本特征。所以说，一般他至少不会体温低，一般都体温偏高，那才能叫做表证。那么要这样的话，就没有表寒证了？这不对，肯定是不对的。

那么，咱们再看看中医理论对表热证、表寒证的概念是怎么解释的？《中医辞海》里边就这么解释：“表热证：是一个病证名，指的是感受风热阳邪所致的表证”。是指的人体感受了中医定义的那种“风热”，这样发生的表证就为表热证。那么，表寒证呢？是指的“风寒侵袭肌表所致的表证”。这是指的以外界的致病因素寒热来界定表证

的寒热，这是一种解释。

我还找到另一种解释，就直接跟咱们这个条文里边有关的。“中医药学高级丛书”里的《伤寒论》部分里，解释了这个条文里边“协热利”。怎么说的呢？是指下利协表证而言，“协热”者，指兼表证发热、下利。也就是说，既有表证发热又有下利。这儿的热，指的是表证发热的病情，还是说的体温高，而不是外界风热的因素造成的这种疾病。这又是另一种解释。

现在随着人类对疾病的认识不断地深入，现在已经知道，自然界的各种的致病因素，之所以能够造成人体发病，只不过是它破坏了人体自身的平衡，只是一个诱因。刚才咱们说的那些典籍上的定义，要是来界定经方的话，也不够确切。外界的温度高造成的表证，就是表热证；那么，外界的温度低造成的表证，就是表寒证。现在没有任何的人可以拿出任何的证据。说明人体感受了风寒了以后，他只得麻黄汤证，而绝对不会发生桂枝汤证或者其他的方证，没有这样的证据。就说，你感受了风寒，一定会得寒性的表证，没有这个规律存在。

感受风寒非常常见，就我们平时生活当中说的着凉嘛，不就着凉吗？着了凉以后，有时还会得麻杏石甘汤证呢？换一种说法，没有什么事实能够证明，某个方证，麻黄汤证、桂枝汤证、桑菊饮、银翘散等等这样的方证，一定是在感受了风寒或者感受了风热之后，才会发生的。

随便拿出来一个方证，比如桑菊饮，时方里边解释它是治风热型感冒嘛。这一类的方证是不是一定得夏天得啊？冬天不会发？感受了气温低，来了寒流以后，人得感冒，就不会得这个方证？根本就没有这种规律存在。也就是说，用这个来界定表寒表热，本身就没有理论和实践的基础。

那么这样，咱们就又回到了这个问题的起点，表证的寒热是什么？表证有没有寒热？要想得出这个结论，咱们还得从经方的方证当

中来分析表证寒热的实质。

解表剂按经方说，寒热大致可以分这么两大部分：

一个是温性的解表剂，麻黄汤、桂枝汤这都是典型的方剂。第二种是凉性的解表剂，经方里边最典型的的就是竹叶汤（竹叶 20 克 葛根 9 克 防风 桔梗 桂枝 人参 甘草各 3 克 附子 6 克 大枣 5 枚 生姜 15 克），这是一个最典型的凉性的解表剂。当然它这里边有一点阴证。

另外一个可以算作寒性的，就是葛根汤，或者说桂枝加葛根汤。

那么咱们看看温性解表剂的方证：这两个代表方剂当中，都有发热一证。但是这个治疗方剂中的药物，几乎没有一味是寒性的药。就是说稍微偏一点寒的也不明显，基本上都是温热药。所以后世不是一直在说“甘温除大热”嘛。所以说表证的“寒热”显然不是指的体表温度所说的。也就是说“中医药高级丛书”里边的那个解释不对，它不是指的体表温度所说的。

那么我们再看看凉性解表药：凉性解表药方剂当中，这种方证也完全可能出现“恶寒”的症状，竹叶汤，或者葛根汤，或者桂枝加葛根汤，完全都有可能出现恶寒。所以说患者主观感觉有没有恶寒，也不能用来界定表证的寒热，也就是说恶寒也不能算。

刚才说了外界的因素不能来界定表证的寒热，因为它没有那个规律；那么体表的温度也不能用来界定表证的寒热；现在说病人的主观感觉也不行。

其实我们换一换角度来想：就是说所有的温性解表方剂的适应证中，一旦出现“里热证”，那么这个方剂的组成就得随之而变。比如大青龙汤、小青龙汤加石膏、麻杏石甘汤，都是这一类的方剂。就是表证一旦有了“里热”了，那么药物就得跟着变。那么反过来，如果说表证同时又有“里寒”的话，那么治疗方剂也要随着变。咱们现在学的桂枝人参汤就是一个很好的例子。真正有了里寒了，你用桂枝汤也不行。

由此可见：表证并没有治疗意义上的寒热存在，没有。体表温度高低也好，外界环境是高温低温造成的表证也好，还是病人自己的主观感觉也好，对表证的治疗都没有影响。影响的是什么？影响的是症状，只有“症状”才能影响到治疗。

咱们再进一步看看这个症状到底是什么？凡是热性表证，都有里热或半表半里有热；凡是寒性表证，都有里寒或者半表半里有寒。

那么就出现了一个不能回避的问题了：就是如果“表证没有寒热”的话，那么经方理论的这个寒热属性指的是什么？

咱们要解答这个问题，还得从经方方证当中寻找。麻黄汤证和桂枝汤证，是典型的表证，一虚，一实。也包括麻黄汤和桂枝汤合方（像桂枝二麻黄一、桂枝麻黄各半汤），这些方证都没有明显地寒热倾向。一旦有了热证，那就是其他方证了，大青龙汤证，厚朴麻黄汤证，白虎加桂枝汤。这都是既有里热，又有表证。当然这里边里证的成分和表证的成分，各占的比例有不同的，那个不是我们现在讨论的。可见这个热就是里热，实际上就是里热。凡有热都是里热。我们说一个典型的方剂，小青龙汤加石膏，在小青龙汤的基础上有了烦躁，有了石膏证，归根到底还是有了里热的征象。我们在临床当中不一定真的有烦躁，我用小青龙汤就看看他脉有点数，舌苔有点黄、有点厚，或者说口有点干，你只要能确定他有热象了；但是他又有表实证，又发热又咳嗽，小便又不好，用小青龙汤加石膏就可以了。你认为他是小青龙汤证，那么你就用小青龙汤，你得加石膏。实际上这就是有了里热证了，而不是表热证，跟表没有关系。

另一类呢，表证的同时伴有半表半里的热证，像柴胡桂枝汤证，还有葛根芩连汤证这一类的。

还有一类，像葛根汤、桂枝加葛根汤、竹叶汤这一类的，我们一般地说，都认为这是表热证。但是，凡是用来界定这个人存在热证的那些症状，实质就是里热。咱们说葛根汤吧，葛根汤在人体没有明显

的寒热倾向的时候，它就治表实证，同时又见项背强几几的。如果有热证的话，条文里边说的是太阳阳明合病，他得的是热性下利。热性下利不就是里热嘛，说到底还是里热。

那么我们再来看看时方：

时方桑菊饮是典型的治风热的方剂。它的适应症是什么？书上是这么写的：风温初起，但咳，不甚身热，口微渴。

这儿的“风温初起”应该说是一个病理的解释；“咳”这是一种表证；“不甚身热”，有点像麻杏石甘汤的“身无大热”；“口微渴”就是“口渴”嘛，程度不很严重。这不是里热的症状吗？怎么能认为这是表热呢？这也不是表热证，就是在表证的同时存在着里热。

如果把桑菊饮和麻杏石甘汤比较一下的话，病理上非常相似。只是桑菊饮对的这些症状反应，都没有麻杏石甘汤的症状反应那么强烈，没有那么重。

还有一个温病里边很典型的方子就是银翘散：它的症状反应是这么写的：口渴、舌尖红、苔薄白或薄黄、脉浮数。大家看看一派热象。这个症状反应我只是挑了一部分，其他的跟我们说的这个问题无关的，那些表证咱们就去掉了，这不都是一派的里热嘛！所以所谓的表热证，或者风温病，无非是表证和里热证同病，无非就是这么一个问题。如果没有里热，或者半表半里之热的话，这个表热证也就不复存在了。大家想想，所有涉及到表证，谈到表热证的，那些热证的反应症状其实都是里热证，你要把里热证这些症状都给它抹掉的话，剩下的就是纯表证。

进一步地我们可以这么说：实际上凉性的解表药，刚才咱们说的桑菊饮里边桑叶、菊花，经方里边葛根是一个最典型的凉性的解表药。所有的既能解表又能清热的这些药，解表功能解的是表证，清热清的是里热，或者说是半表半里热，都是这一类的情况。

所以说表证没有寒热，我就这么说的“表证无寒热”！

但是“表证无寒热”，那么体表温度的高低，确实是存在着的一种事实。而且有时候因为体表温度的升高，严重地会致人死亡的。那么这个到底是什么啊？实际上这就是人体在表证的这个病理阶段，抗御疾病的一种形式。表证的体温增高，它想用提高体温的方式，形成一种抗御外界致病因子的环境。它想通过提高体表体温的这种办法，形成一种不适合致病因子生存的环境，这是人体自身抗御疾病的一种特殊的本能。但是它反映的不是疾病的本质，你治它没有用，它对疾病的治疗没有影响。真正在寒热方面有影响的，都是里证和半表半里证出现的寒热，对治疗才有影响的。说明里证的寒热和半表半里证的寒热，代表的才是疾病的本质。

那么既然说表证没有寒热属性，那么这个条文里边的“遂协热而利下不止”，这个“协热”这两个字，今天我们就应该把它理解成是“表热内陷”，就不要这么理解，这不是事物的本来面目。这是古人对于表证治疗不当，而诱发下利这一类的情况，在当时的历史条件下所作的病理上的解释。

话又说回来，这个问题关系到中医里边的基本概念的问题，而且这种提法我还没见到有谁这么提过。我之所以拿出来跟大家一块儿讨论，是我经过反复考虑的。可是就凭我的这一己之见，分量太轻了。那么它是不是这样的？还有待于大家进一步地讨论，我现在提出这么一种观点来，大家可以一块儿去讨论。对也好，不对也好，但是讨论本身，对我，对大家都是有好处的。

条文的下边：“心下痞硬”，跟三个泻心汤的“心下痞硬”是一样的，因为里虚寒所致的。

“表里不解”，就是虽然经过数次误下了，但是表证仍然存在。即出现了里虚寒，但是也有表证还不解的情况。

这个时候出现了因为里虚寒造成的“利下不止”的这种症状，按照经方的理论，应该是先温里后解表。但是这个条文的意义就在于一

且表证和里证同时存在，而且里证又是一个里虚寒证的时候，你可以同步进行治疗，具体的方剂就是“桂枝人参汤”。

那么学习 163 条，咱们至少应该理解这么几点：

第一个就是表证误治以后，出现的变证是多种多样的，有一个多样性。表证误治以后，由表实证变成表虚证的；或者出现里热证的；或者出现里实证的；或者出现气逆证的；也有陷于阴证的。但这儿呢，论述了误下以后，表不解，又出现了里虚寒证的这么一种情况和具体的治疗方法。这是我们应该理解的一点。

再一点呢，按照治疗原则，表证和里证同病的，里证属于虚寒的，先温里后解表。那么这儿呢，又给我们说了另一种可以治疗的方法，就是说表证和里虚寒证可以同时治疗。那么为什么强调这一个？因为在后边有出现里实热证以后，不能同时治疗的，所以说条文的意义就在这儿。不能笼统地说：出现里虚寒的先温里后解表，出现里热的先解表后清里热。但是有的可以同时进行，有的不可以同时进行。里热证也有可以同时治疗的，大青龙汤证，也是解表和清里热同时进行的。

这个方证的病理：里虚寒证合并表虚证。

下面做个小结：

太阳病在表证还没有解除的情况下，而数次施以下法，随即造成患者利下不止、心下痞硬，此时如果表证仍在的，为桂枝人参汤主治之证。

下面呢，我们看看这个方剂。这个方剂，可以理解为理中汤加桂枝，也可以理解为桂枝甘草汤合理中汤。这两种理解法呢，后面反倒比较确切。桂枝甘草汤，可以视作是桂枝汤的一个最简方。理中汤是第 386 条和第 396 条里的一个方剂，主要用来治疗里虚寒证所造成的下利呕吐这一类的症状的。在这一个方剂当中的作用也不例外，无非也是治疗因为里虚寒证造成的下利。关于理中汤的这个作用，我们在以后的学习当中再详细地跟大家介绍。

最后一个小问题呢，就是方后注有一个“日再，夜一服”。有这么五个字，在《康平本》里边，我们清楚地能看到这五个字是后人所加。

方证的症状：下利、心下痞硬、发热、恶寒、食欲不振、神疲乏力、脘腹痛、腹胀、头痛、手脚冷、呕吐、面色苍白、咳嗽、气急、头重、心下悸动、泛吐清水。

舌质：淡舌。只有这一种舌质。

舌苔：白苔、无苔、灰苔。

脉象：弱、数、沉、缓。大家注意这里出现了数脉，这个数脉是阴虚，候虚，肯定不是候热了。

现代疾病：感冒、流行性感、胃肠性感、急慢性胃肠炎、慢性浅表性胃炎、萎缩性胃炎、急慢性肠炎、慢性结肠炎、胃及十二指肠溃疡、胃下垂、胃疼痛、慢性肝炎、慢性胰腺炎、病毒性肺炎、顽固性荨麻疹、习惯性头痛、麻疹、心肌梗塞、小儿重型肺炎、小儿秋季腹泻、病窦综合症。

伤寒、大下后、复发汗、心下痞、恶寒者、表未解也·不可攻痞、当先解表、表解乃可攻痞、（注）解表宜桂枝人参汤①·攻痞宜大
黄黄连泻心汤·（164）

注：“解表宜桂枝人参汤”《宋本》作“解表宜桂枝汤”。

胡希恕：这个太阳伤寒，大下是非法的治疗了，应该先发汗，大下当然不好，他一看不好，他又复发汗更错，既大下表不解，依法应用桂枝汤，不能用麻黄汤，他这个复发汗就是指麻黄汤，那大汗出，病并不解呀，他的表还不能解呢，所以他一方面由于他这个大泻下使表邪内陷而为心下痞，一方面由于发汗又错，所以仍然恶寒而表不解，要吃桂枝汤他就对了，那这个表不解而有这个心下痞，那么应该先解

外而后攻里，所以他说不可攻痞，当先解表，这是根据这个规律了，所以在临床上，如果要是用这种里实需要用攻下的药，那你看外，要有表证，你先解表，这是定法，如果里面要温，你先救里而后攻其表，所以这个他那个太阳篇他这个都讲了，他应是这个表证与半表半里与里证的相互关系治疗定法，他在这里都讲了，太阳篇的特别多，我们到阳明病到少阳病，他讲的都少了，他原来在这里都讲了，那么这里你要注意了，如果用攻下的药，有表证在，应先解表，我们头前讲的十枣汤都是的，十枣汤你也不能先用十枣汤，要攻呀，所以得先解表，表解之后，那你再攻里，所以是里未和，表解里未和呀，所以用十枣汤，这也是一样的，一个痞，他用大黄黄连泻心汤，他这是一个攻的一种，这都讲的头前了，这个大黄黄连泻心汤，也讲在头前了，这个解表呢，所以这个津液已经丧失了，这个解表不能用麻黄汤，必须用桂枝汤，头前大下之后表不解，也应该用桂枝汤，所以他这个复发汗就是用的麻黄。

李冠杰：这条文在《康平本》是顶格排版的条文。

嵌注“解表宜桂枝人参汤”，在《宋本》里这句被改成了“解表宜桂枝汤”，方剂上有差别。

解读一下：

“伤寒大下后，复发汗”。表证先下后汗，就严重违反了经方的治疗原则。表证不该下，用了下法，而且还是大下；下后不能发汗，发汗指的是麻黄剂之类的发汗解表药，大下之后又给了发汗药，等于是连续的误治，很容易发生变证。

“心下痞”，这是出现的症状，是这条里论述的一个关键性的症状反应。条文说得非常清楚，仅仅表现为痞，没有痞硬或者痞满这类的症状。它就暗含着没有里实证。看看后文中的“乃可攻痞”，可以知道这应该是热痞，不是虚寒证所造成的心下痞，这个证就可以明显地把定性了。

“恶寒者”，既然是误治以后发生的里热，“恶寒”就必然是表证未除的症状反应。因为有里热，通常情况下不应该恶寒，应该是不恶寒但恶热。有恶寒的症状说明还存在着表证，表证没有完全消失。

这个旁注“表未解也”，给做了进一步的解释，很明显能看出来这是表证存在的征象，这个地方说明得很好。

“不可攻痞，当先解表，表解乃可攻痞”。这是本条文论述的重点。“心下痞”是症状反应的一个重点症状。这个“不可攻痞”和“表解乃可攻痞”，就给前文里的心下痞定了病性，就明确了是一个热痞。

“当先解表，表解乃可攻痞”，就是论述的一个治疗原则，就是在这种情况下不能用“表里同解”的方法。前边的条文里有桂枝人参汤，桂枝人参汤证就是表里同解。这是既有表证又有里证，但是这个里证是里热证，需要用攻下的办法。这个时候就不能用同步治疗的办法，作为一个治疗原则。

经方的治疗原则，都是跟人体的生理病理规律相适应的。第 163 条就论述了表里同病，当里证为虚寒性疾病的时候可以表里同解。就是因为它既存在着里虚寒证的病理状态，人体又有从表证阶段解除疾病的趋势，当把里虚寒证给解除了之后，随着人体能量的增加，尽管解表的力量不是很大，就一味桂枝，同样可以达到解表的目的。就像打仗一样，本来在外面的战线上自己的部队有能力抵抗，没有放弃，一旦其他地方的援兵再增加一点，获胜的几率就会高很多，获胜把握就比较大。

第 164 条是表证和里证也是同时存在，但是里证是热证。为什么不能用同步治疗的办法呢？这里不是一般的热证，而是需要用攻下的方法来治疗的热证，凡是这类的方剂都是攻伐的方法，对人体的内环境都有一定程度地损耗。当治疗的时候，一方面内脏器官、人体处在比较亢奋的状态，有明显的里热；另一方面，人体还有从体表解除疾病的趋势。这个时候如果先去攻里，里证可能会解除了，这时的人体

的能量常常不会增加，尽管内部理顺了，但能量的增加还得有一个过程的。通常攻下之后，人体能量会降低，解表的能力也会随之降低。这样不单单表解不了，恐怕攻里的效果也要受影响，可能会产生其他变证。这样的情况在白散方剂的方后注里说的挺清楚：像那类攻下的药吃完了以后得“糜粥自养”。这就非常清楚地告诉我们，攻下的力量虽然没有大陷胸汤那样重，但是相对地攻下的力量比较重一些；就算是大黄黄连泻心汤这类的药，即使它没有那么大的泻下力量，它也没有增强人体能量的效果。我记得上次说过三黄泻心汤，也就是大黄黄连泻心汤再加上黄芩，本身这个方子里就应该有黄芩。这个方剂要是真正有里热的时候，吃一次，对了证感觉会非常舒服，但吃得过了以后，浑身地疲乏。所以说经方的治疗原则都是跟人体的生理病理规律丝丝入扣的。

第 164 条论述的重点就是要阐明当表里同病，里证为热证需要攻下时候的一个治疗原则，但是不需要攻下的这类方剂，不在这个治疗原则之内，比如大青龙汤证就是外有表证、里有内热；像葛根汤证也是有某种程度的内热，那是可以同时治疗的。那些用不到大黄，它是清肃里热，不是泻下。这个条文里列举的“心下痞，恶寒”，得有症状反应，它说明伤寒误治以后表证仍然存在，同时又出现里热的两个例证，只是列举了两个例子而已。至于说具体的治疗在其他条文里都有论述，而且临床中也不一定仅仅就限于这两个症状。所以这儿有意识地没给出具体治疗方剂，重在阐明治疗原则。

但是，历代学者读到此类的条文，几乎都想给它确定具体的治疗方剂。条文后边的注解内容就是属于此类的情况，既然说有症状就应该能治，拿了两个方剂放在这儿，第一次还感觉不合适，第二次修订的时候又做了一次更改。实际上本身就能说明问题原文作者论述的重点不在如何治疗，因为治疗在别的地方都有，这里重在说明治疗原则，理解到这儿就可以了。如果非要给这种情况套上方剂，那就不是

一两个方剂的问题，可能涉及到比较多的方剂。其实没有必要，学这个条文只要知道了治疗原则就可以了。

在《康平本》里条文后头的注解：“解表宜桂枝人参汤，攻痞宜大黄黄连泻心汤”，到了《宋本》就改成：“解表宜桂枝汤，攻痞宜大黄黄连泻心汤”。大家都知道，表证经过泻下以后，如果表证仍在的宜用桂枝汤。这个用桂枝汤是在第二次整理的时候加的，谁加的不好定论。但是说改肯定是王叔和改的，因为《康平本》里是一个样子，《宋本》又是一个样子，咱们早就探讨过，其他人改得可能性非常小，就王叔和改的。他为什么改呀？因为他也看到了外有表证、里有热证，如果再用桂枝人参汤，那么多治疗里虚寒的药肯定不太合适，就把它改成桂枝汤了，而且这个也有依据。

但是在临床中桂枝汤也未必合适。因为这个时候人已经有里热证了，这也是桂枝汤的一个禁忌症。桂枝汤表实证不可用，有里热的也不可用。大家可能会说桂枝汤本身是一个温热药，有里热如果不能用桂枝汤的话，那该用什么方剂呢？比如用桂枝加葛根汤，它就比较偏寒些了，没有桂枝汤那么热了；还有竹叶汤，如果出现阴证的话，用竹叶汤的机会也有。总之这个地方就重在了解它的治疗原则。

伤寒、发热汗出不解、心中痞硬、呕吐而不利者、**□□**
□□之^①、（165）

注：“□□□□之”《宋本》作“大柴胡汤主之”。

胡希恕：“心中”不对的，是“心下”，把它改过来，这个心中呀常指心脏说的，这个心下指的胃说的，就是在心口这位置，心下痞硬，呕而不利者，大柴胡汤主之，这形似太阳伤寒，汗多发热，但是他没有畏寒啦，所以汗出不解，心下痞硬，这个心痞硬是个实证，不是我们说的人参那个心下痞硬，这个就是心坚满，呕吐而不利者，同

时呕吐与下利，这个大柴胡汤主之，那么这个病指的是什么呢，就急性痢疾，这个很多呀，这个急性痢疾呀，他来他也发热，但是有恶寒呢，我们用葛根汤就对了，这个要注意，这一段啦，应该与葛根汤有个鉴别，咱们头前讲了，太阳阳明合病，必自下利者，葛根汤主之，那个绝对的纯粹是太阳病，还有恶寒脉浮，他这个有下利，解表下利就好，那么如果也是发热汗出，也恶风或恶寒，但是脉缓弱，那是桂枝汤证，所以我们在后头有，到太阳病篇有，太阴病脉浮者可发汗，宜桂枝汤，那个跟用葛根汤是一个道理，所以我们在临床上，遇到这种痢疾呀，如果有表，实痢可用葛根汤发汗，虚痢可用桂枝汤解肌，这个表解，他这个痢疾呀，大致就可以好，就是不好，也减去凶势，你再……治疗，他也比较容易，那么这个呢他不是伤寒发热，他没有恶寒，那么这也就是给误治了，所以发汗不解，同时马上这个病就来了，心下痞硬按之也拒按，也疼，也准疼，呕吐而下利，上头呕吐，下边利下，这个病很多，这个急性痢疾如果有热的话，或者恶心、呕吐，这个柴胡汤，这个心下急呀，咱们头前已经讲了很多了，心急，他这个痞硬与那个是互词，急就是这个位置觉得憋得痛，这个急，不宽楚嘛，这个李东垣，他注的就是不宽快，不宽快就是紧，同时他这个痞硬，……里头有东西了，痞硬，呕吐而下利了，这个很多，开始就用大柴胡汤，那么如果要有口臭感，也可以用大柴胡加石膏，急性痢，也很好使，我还记得，那回我来北京，就在大街上，我没到这里来，我私人开业，有一次我出诊了，后来店里来了一个人，大概就是这种痢疾，有一个学生跟着，我回来问他，有病人没有，他说有呀，我问是什么，他就说是这种病，他说一个闹痢疾的，我说闹痢疾的，你开了方子吗？他说我开了，我说开什么，他说大柴胡加石膏，哎呀，我不放心，他这个病离我家不远，我说得了，我看看去吧，完了他带着我看去了，这个病人正来茅房里，完了他出来了，我说怎么样，他说挺好，现在我肚子也不疼了，也不发烧了，大便也渐……。所以这

个方子很好，我怕他全弄坏了，特意去看，这个有很多的，那么假如说，他这个心下不痞，不是这样子而拒按，原来这种痢疾也发热，呕吐下利，这个呕吐不好哇，这个痢是噤口痢呀，就是呕吐，什么也不能吃，这个痢疾死亡比例很大呀，一般用小柴胡加石膏也可以。我用小柴胡加石膏汤，这个人现在还活着了，他的弟弟前天上我家串门来了。所以他这个痢疾用柴胡证的机会很多，尤其大柴胡汤，痢疾开始呀，没有补法，那么这个大柴胡汤的泻下作用不大的，只是，现在我们用大黄 10g 或三钱，我自己闹痢疾也吃这个药，他一泻就好，这个病来的挺厉害，那个发热呀，……也吃了，来得挺凶。

李冠杰：“伤寒，发热汗出不解，心中痞硬，呕吐而下利者”，这儿有四个缺字符号，后边是一个“之”。应该是 XXX 方，XXX 主之。这个条文在《康平本》上是顶格的条文。

条文最后的四个缺字符和一个“之”字，在《宋本》里边给改成了“大柴胡汤主之”。《宋本》里边，它是说这个条文的治疗方剂应该是大柴胡汤，“大柴胡汤主之”。后边咱们再看看对还是不对。

下边咱们解读一下。

“伤寒，发热汗出不解”，这儿应该就是指表的证发汗以后，表证仍然不解的意思。

“心中痞硬，呕吐而下利”，我们参照一下其它条文分析的话，这儿应该是指的发汗太过了，所以说出现了变证。不单单表证没有解，反而又出现了里证。

“心中痞硬”，就不太好理解，因为这个条文当中最后边的治疗方剂缺失了，我们失去了一个很重要的参照。大家看啊，在经方书籍论述的条文里面，有许多的条文论述得非常地简，比如第 62 条：“发汗后，身疼痛，脉沉迟者”，这些症状就相当的简了，但是它后边有新加汤这个方剂。你看看那个新加汤，马上就明白它还可能会有什么样的证？“以方测证”嘛。所以说它可以简。这个地方本身它症状列

举得也比较简，但是它方剂丢失了。这个与作者无关，就是说这个书在流传的过程当中，这个方剂残缺了。不管什么原因吧，你要如果再想“以方测证”，没有了，所以说失去了一个很重要的参照。我觉得啊，既然没有了就不应该去强作解释。当然有的比较明显的，还是尽可能地做出恰当的解释。要说不好解释，咱们慢慢分析。

这个条文可以用来分析方证的症状反应，就仅仅有一个“呕吐而下利”。因为这个“心中痞硬”这个不太好理解。“心中”一般就指的胸部，胸部“痞”还可以理解，但是这个“硬”就不好理解了。所以说这个症状本身就有疑问。那么剩下的没有疑问的，就是一个“呕吐而下利”。但是“呕吐而下利”这样的症状涉及到的方证，就非常得多了。你简单地一想：理中汤证就有；五苓散证也可能有；三个泻心汤都可能有这一类的症状。所以仅凭着这个现有的资料看，很难为它缺失的这个方剂，确认具体是哪个方。

《宋本》当中最后把它改成了“大柴胡汤主之”，这个也是经过了非常慎重的考虑的。先说改这个的一般的说，恐怕只有王叔和了。他第二次整理总觉得这么重要的地方如果缺失了，不太像话，后来他肯定是经过再三考虑的。因为他挑选的这个方剂，跟原书的那个空，就是缺字的字数不相吻合。别说王叔和那种有学识的人，就说一般的人，稍微懂点中医的人，也会非常非常地慎重，因为它不一样。应该是个三个字名字的方剂，因为它有后边这个“之”字就很明确了，它不会是其它的宜什么汤或者什么的，它不会是那样。

胡老作的解释也非常客观，因为胡老他没有见到过《康平本》，那么就顺着《宋本》在解释，也等于说，为这种改动，作了合情合理的解释。就是说大柴胡汤，如果把“心中痞硬”理解成“心下痞硬”的话，又有呕吐又有下利，有用大柴胡汤的机会。当然如果再有“往来寒热”之类的，当然就会更确切一些。

我个人看这个地方，我总这么觉得这个地方应该深入地研究，不

应该轻率地作最后的结论，应该是让它各个地方都得相吻合。可这儿有一个大概，可能凡是学这个的都会有这么一个疑问？说这个原文当中有四个缺字符号，那么它准是四个吗？大家可能会有这样的疑问。既然这个书已经是个残缺了的，那怎么就这么准确它就是四个字呢？这个是跟那个竹简是有关系的。这一个竹简上写的字数都是有限的，不是说乱写，不像我们现在一样在书上打草稿划线写这么乱，一个竹简上多少个字，都是有数的。所以说再加上它后边最后一个字还在，像竹简上写字也不会特别得小，像说这个数字不准的可能性不大。所以说这个地方我们还是存疑吧，大家可以慢慢地研究，慢慢讨论。

而且这个呢，是我们看到《康平本》以后，重新提出来的。就是说快两千年了，从宋代一直到我们现在，这是又重新提出来这个问题。确实需要慎重地研究。

病如桂枝证、头不痛、项不强、寸脉微浮、胸中痞硬、
气上冲咽喉、不得息者、当吐之、此为胸中有寒饮也^①·宜瓜蒂散、
(166)

注：“当吐之、此为胸中有寒饮也”《宋本》作“此为胸有寒也，当吐之”。

瓜蒂一分熬黄 赤小豆一分

右二味、各别捣筛、为散已、合治之、取一钱匕、以香豉一合、用热汤七合、煮作稀糜、去滓、取汁和散、温顿服之、不吐者、少少加得快吐乃止、（注）诸亡血虚家·不可与瓜蒂散·

胡希恕：所以桂枝汤主要治气上冲，那么寸脉也浮，他这个病在上，那么这个也是，这个寸脉讲那个脉促者表未解也。结胸寸脉也浮，他这个病在上，那么他这个也是，这个寸脉微浮哇，对照这个桂枝汤讲，他形似桂枝汤，桂枝汤证寸脉必浮，那么同时气上冲，但与桂枝

汤，似是而非，桂枝汤证，头部，他为太阳病嘛，他一定有头项强痛，这个头不痛项不强，那么这个病是什么病呢，他底下就解释了，胸中痞硬，病在胸中，胸中痞可以理解，他这个硬，不好理解，……胸憋得厉害，那个胸有肋骨，怎么能摸着它硬啦，当然在心下摸，心下这儿可能也硬，他是往上，这个往上攻得厉害，换言之，感觉得这个胸憋得厉害，按之心下这地方也可以硬，气上冲咽喉，感觉着这个气上冲的厉害，所以说证如桂枝汤证，不得息者，以至于呼吸都困难，这个呼吸困难有二方面的问题，一个是胸中痞硬，一个是气上冲咽喉，二方面造成的，它堵得咽喉，也影响不得息，这说明什么问题呀，就是这个病呀，由下往上，它又要想吐，又不得吐，所以这个人呐，这个时候必然有愠愠欲吐，要吐而不得吐。所以他下一个断语是胸有寒也。这个寒是指水饮说的，水饮也要从上面出，当吐之，宜瓜蒂散，所以中医治病它这个辨证啊很有道理，他是要用吐剂，这个病往上来，这是个病机嘛，咱们讲病机，这正是个病机，就是在生理机制上它有这个机制，想要把它从口腔把它吐出来，但这样它达不到，要吐而不得吐，所以胸中也痞硬，气感觉往上冲而致不得息，他用这个吐法，最适应病机了，所以用瓜蒂散，瓜蒂这个药，它是苦寒祛水的药，所以它也治浮肿，那么它是苦寒的，它有涌吐的作用，它祛水，有吐下，上面吐，这个药也能随水饮而下，但它主要是涌吐，赤小豆也祛湿，在这里头它一方面，赤小豆也有点祛湿之功，与苦寒药搁在一起它也有养正的作用，那么这两味药，各别捣筛，为散……，合治之，把它调匀取一钱匕，以香豉一合，用热汤七合，煮作稀糜，把这个豆豉啊用咱们这个碗，七分碗、八分碗这个样子，把它煮成稀粥的样子，……然后把这个滓子不要，取之和散，用豆豉的汁合这个……药顿服之，不吐者，少少加，要是不吐把这个……的药再少少加，得快吐乃止，诸亡血虚家，不可与瓜蒂散，所以这个吐也最伤人不可，我们看看这一节，它这个用豆豉，豆豉它是解烦，它……欲吐，也烦，它并不是

个吐剂，不吐者少少加，叫加……药，我们讲的这个栀子豉汤，所以这个注家看有这个香豉，也说它吐，栀子豉汤它不是吐的，就从这他是弄错了，他看这个里头有香豉，在栀子豉汤里也有豉，他一看这也是吐药，所以咱们这个头前讲的栀子豉汤，在临床上我一直常常用，没吐过一回，它不吐，它就治虚烦，心中懊恼，就是这个药他看中香豉了，所以他说助吐，不是的。

李冠杰：这个条文在《康平本》里是降一字格排版的条文。

这个旁注“此为胸中有寒饮也”，在《宋本》里边改成“此为胸有寒也”。

下边我们解读一下：

“病如桂枝证”，患者在症状反应上有与桂枝汤证相似的地方。像气上冲，发热，汗出这一类的症状。在瓜蒂散证当中，会有存在的可能性。

“头不痛，项不强”，如果仅从字面上来理解的话，就是本方证不应该出现这一类的症状。但是在实际临床当中，瓜蒂散证里边确实实有头痛一症。在临床统计资料中有，而且不是一个医案有。虽然说症状特别像桂枝汤证，但是经过脉证合参以后，最终得出来结论：不应该有表证。这个就符合经方的治疗原则了。

那么“寸脉微浮”，咱们前边学过“但寸脉浮”，只是寸脉浮的话，那么就是促脉。“微浮”呢，可以理解成轻微的，比较轻度的促脉。从脉学的角度看呢，瓜蒂散证属于胸膈部位的疾病，应该现这样的脉象。上焦的疾病，出现这种脉象，在脉学的角度来看是很正常的。

但是，从临床实践这个角度再去看，与这个论述不相符。这一方面的临床统计资料显示瓜蒂散证有 35 个医案的统计记录，17 例有脉象的记载，但是这 17 例当中，寸脉别说微浮了，记载寸脉和寸脉浮的这一类情况的，一例没有。这样我们可以证明一个问题，这个方证里边绝不会仅现此脉，至少可以证明这个问题。

不能把哪一个病或者哪一种病理状态，固定在一个脉象上，或者必然会出现这种脉。那是机械的、教条的，不对。因为临床实践不支持这一类的观点。

“胸中痞硬”，这儿的“胸中痞”，应该是指患者胸部有痞塞不通的感觉，应该是指这类的症状。但是这个“硬”，跟刚才我们说的“心中痞”一个道理，不太好理解。因为人体的胸部有肋骨支撑着，似乎没有软硬之分，没法去辨别它的硬软。这样呢有好多学者就认为这个“硬”，应该指的是腹诊中的，像胃部或者肋下的地方存在着硬满的问题。从我们手头上掌握的资料全面地来看的话，还有其他的问题，大家来看一看有没有道理？如果对临床医案进行一下分析，会发现这个方剂所治疗的疾病当中，其中有乳房肿块，恰恰这一个医案的乳房肿块，不是妇科里边的乳腺病，而是男性的乳房部位的肿块。那么这个地方的“胸中痞硬”是不是指的是这一类的情况？值得我们深思。而且呢，在这个方剂治疗的现代疾病里边，除了乳房肿块之外，还有乳腺方面的一些病。

“气上冲咽喉，不得息”，这是这个方证的一个较为典型的症状反应。这个“气上冲咽喉”与桂枝加桂汤和奔豚汤中的“气上冲胸间”，仅从字面上看，似乎觉得差不多，但是发病机理根本就不相同，不是一回事。这个“气上冲咽喉，不得息”是由于热与痰饮积聚于胸膈部，当然也包括胃部了。人体还同时形成了一种很强的自上体部排出疾病的这么一种趋势，才表现出来的这种症状。但是桂枝加桂汤、奔豚汤那一类的方证，不具备这种特征，它是“气从少腹上冲胸间”。瓜蒂散证没有少腹悸动那种症状，气也不是从那个地方冲上来的，就是胸部胃部满，这是最典型的。

“当吐之”，反映出了中医因势利导的一个治疗理念。瓜蒂散证虽然在病理上，跟结胸证比较类似，都是热与水结于胸部也好，胁部也好或者上腹部也好。但是瓜蒂散证有自上而解的这种生理机制，所

以说就要用吐法；而结胸证没有这种机制，所以要用下法。这还是建立在人体的生理和病理的规律之上的。

旁注：“此为胸中有寒饮也”。这句话对病位的解释应该说是比较确切的，因为这个方证主要的发病位置就在胸和上腹部；但是对病性的解释应该说是完全错误的。瓜蒂散证是一个热性的疾病，没有任何寒象的证据，没有寒证。虽然有停饮证存在，确实有停饮，但是这种停饮是在半表半里有热的情况下发生的。而且停饮证本身，是一个体液代谢方面的疾病，停饮就是津液积滞，就是津液该行的不行了，该走的不走了，并不能说明它们的寒热倾向。

有相当一部分学者认为：凡是饮证就属阴、属寒。实际上，这都完全不对。大家看一看，猪苓汤证。猪苓汤证的阴证何在？猪苓汤证的寒证何在？没有！这是典型的热性的停饮证。而且它热到什么程度？热到连白术这种稍微偏温一点的祛水的药，都不能用。最多用了猪苓、泽泻，这都是典型的寒性的祛饮药；再就是中性的茯苓。这说明什么？这说明猪苓汤就是停饮证里边的一个典型的、阳性的、热性的停饮证。那怎么能把所有的饮证都说成是阴性证或者寒性证？这都不对。

实际上饮证本身，体液代谢本身并不能说明寒热的问题。你看猪苓汤证：一方面体液代谢不好，另一方面有里热。

我曾经有一次，对于一个平时里常偏一点虚寒的人，他出现了猪苓汤证。我就给他猪苓汤喝，他喝了一剂，所有的症状都减轻了。他认为效果这么好，就自作主张，把药量加大，而且服的次数也多，本来他好了就应该不喝，就应该停药了，他也没停，就接着往下喝。喝了大概两、三天吧，就开始出现了头痛、恶心，他实际上就是吴茱萸汤证。他后来就给我打电话，我就给了他一次量的吴茱萸汤，喝下去就好了。猪苓汤里边那个滑石，在药性方面跟石膏比较相似，但有一些石膏代替不了的作用，它利水，本身有滑性，能够增强尿道里边滑

利的程度，使人在小便的过程当中，减少那种涩痛感。石膏是没有这种作用的。

这个瓜蒂散证在《伤寒论》和《金匱要略》里边都有论述。《伤寒论》中除了现在学的这个条文之外，还有第 355 条：“病人手足厥冷，脉乍紧者，邪在胸中，心下满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散”。这个条文也是降一字格排版的条文。这个条文当中既有病理解释，也有症状反应。对我们现在学习的条文，可以视作是一种补充。

《金匱要略》里边儿论述：“宿食在上脘，当吐之，宜瓜蒂散”。

把这三个条文集中到一块儿的话，瓜蒂散的症状反应应该是这样的：“病如桂枝证，寸脉微浮，胸中痞硬，气上冲咽喉，不得息，手足厥冷，脉乍紧，心下满而烦，饥不能食，宿食在上脘”。

在实际临床当中，除了条文里边论述的这些症状以外，我们还能看到一些精神和神经方面的疾病反应。除了条文里边有“心下满而烦”，这有个“烦”之外，看不出有任何这类疾病的这种证候。但是临床统计资料统计到的 35 个医案当中，“烦躁狂妄”有 18 例，出现的频率非常高。这说明什么啊？说明人体上部部的内脏器官的病变，特别是一些热性疾病，一些急性的病对神经系统的影响比较大，至少我们可以得出这样的结论。

这个方证的病理：停饮证合并半表半里热证与里实热证。

下面做个小结：

貌似桂枝汤证，但却无颈项强等症状，即无表证；患者表现为寸脉微浮、胸中痞硬、气上冲咽喉，不得息的，当用涌吐的方法治疗，宜瓜蒂散方。

这个方子有三味药物组成：瓜蒂、赤小豆、香豉，就是豆豉。瓜蒂就是甜瓜的瓜把，就是那个柄。在方剂当中是主药，药性偏于寒，有毒，有催吐的作用，还有退黄的功能。赤小豆也是一个寒性的祛水

的药，有一定的补益作用，与瓜蒂合用，既能增强祛水的力量，又能缓解瓜蒂强烈地催吐作用对人体的一些损伤。淡豆豉是寒性的、去热解烦的药，同时也有一点补益作用，而且有开解胸咽部的郁结这种作用。

这个方剂的服用方法在经方当中，相对的比较特殊了，要求将瓜蒂和赤小豆先做成散，再用煮的香豉汁往下送。现在临床当中，有按这种古法服用的，也有改为汤剂的，还有呢，吹到鼻孔里边，用来治病的。更有人还试过，把这种方剂制成针剂，通过静脉注射。但是有一点是准确无误的，只有通过口服入胃，才有催吐的作用。静脉注射和鼻腔给药都没有催吐的作用。但是能治病。

方后有一个附注：“诸亡血虚家，不可与瓜蒂散”。这个应该不是虚言。在临床统计资料当中，常有因为服用瓜蒂散不当，而发生医疗事故的，这一类的报道也不是一例。所以，用这个方剂还是要慎重。方后注解说得也很客观，“得快吐”，不要再服了。之所以出医疗事故，主要还是方与证不太相应。

症状：食不下、胸脘痞满、烦躁狂妄、恶心呕吐、尿黄、黄疸、头痛、发热、便秘、突然晕倒、手足不温、咽中异物感、神疲乏力。这儿呢，有一个“恶心呕吐”，这个方证本身就有自上解除疾病的这种趋势。如果吐了以后，他还存在烦躁狂妄类的，食不下的症状的话，这个方剂还是要用的。

舌质：红舌，偏红，明显看出热象，是一个热病。

舌苔：黄腻苔和白腻苔。

脉象：滑脉，弦脉，数脉。

现代疾病：神经衰弱、瘵病、癫痫、癲狂症、神经分裂症、乳房肿块（男性）、早期乳癌（女性）、痰厥不语（精神方面）、黄疸型传染性肝炎、急性黄疸型病毒性肝炎、高胆红素血症、重症肝炎、服毒后的救治。这个方剂应用的面相对来说比较窄一些。

病胁下素有痞、连在脐傍、痛引少腹、入阴筋者、此名脏结、死、（167）

胡希恕：咱们开始这个太阳下篇，就讲的结胸和脏结，结胸讲的很多了，从结胸讲到心下痞，那对于脏结它没有交待，这里他又特别提出来，病胁下素有痞，这个痞就是痞块，这个不是心下痞那个痞，所以在头前，你们看一看哪，开始病发于阳而反下之，热入因作结胸，病发于阴而反下之，因作痞也，那个时候讲的痞，就是指的这个痞块，就指的脏结，它这一开始的4条啊，全……这个结胸和脏结立论的，它这个痞不是指的心下痞这个痞，我们讲到太阴病，它有，太阴病，这个药不可下，下之胁下结硬，胁下结硬是什么东西呢，就是痞块，所以注家把这个痞，也就是弄成后头我们讲的大黄黄连泻心汤这个痞了，不对的，你看那个都是太阳篇、太阳病，下之为心下痞，不是阴证，病发于阴下之，不是那个痞，那么这一段呢，就是照顾头前，所以胁下素有痞，胁下它在两侧，两侧现在咱们很明白，两侧它是肝脾的部位，那么胰腺也在左边，也是胁下，可见这个病它是不能治的，这个我们看得象它指的肝癌，或者是胰腺癌这类东西，你们看一看，那么它不是马上得的，不是由于吃泻药马上就得的，素有痞，痞块连在脐旁，往下与脐旁这个部位相连，痛得厉害，痛引少腹，甚至于下入阴筋，筋经就是指的前阴了，此名脏结，死。所以脏结是……治，在古人呢，也看出这么个问题，你们看看这个……，它是连在脐旁，那么可见古人是对于这个痞也是没办法的，所以这个结胸就讲治疗，这个脏结一回也没说，它就说脏结无阳证，舌苔黄不好治，在这儿呢，它又说脏结死，有这种情形准死，也有不死的，那么那就不一定就是癌了，那是古人对这个证的一种看法，所以你们看这个注家说的这个痞啊，全指的心下痞就不对了，这个你怎么交待呀，这个就是与前边

那个痞，就是那个脏结相呼应的有这么一段。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。

这条在这个地方出现，我们可以把它看做是对结胸证之类的条文做的一个补充。在整个结胸篇里，可以用本条做一个界线。本条之前论述的基本都是跟结胸证有关的内容，像三个泻心汤证，虽然跟结胸证差得很远，但是它在症状反应上有相似的地方，都有心下痞、甚至痞硬之类的症状，所以就把它放在一块儿来论述了；在本条之后的条文，无论是从症状反应上，还是从治疗方剂上、病理状态上，都跟结胸证关系不大，或者说无关。也就是说从这个地方把它分开，原书很可能本条就是结胸篇的结尾了，后边的这些内容不一定在原文的哪个位置呢！但在整理的时候，因为它们都跟太阳病有关，就附在这个地方了，有可能是这个样子，这是一种猜测。但是能从条文的论述中明显看出来，实际上这种猜测并不是毫无根据的瞎想。像这书年代久远了，中间缺字、条文残缺等什么情况都有，咱们都学到快一半了，大家都会有这么一种感觉。所以要是从内容上来看，就能发现它有这方面的特性。

我们再延伸一下，为什么经方理论会用这种很特殊的论述方式呢？比如三个泻心汤证和结胸证，它们不管是病理上也好，真正的临床中的症状反应也好，差距都挺大，从疾病上说差得比较远。但是为什么放在一块儿来论述呢？其实带着这个问题，再回头整体浏览一下经方的书籍就会发现，这是经方特有的一种论述方式，把临床中疾病性质完全不同，但是有类似症状反应的放在一块儿。因为在临床中看病的时候，要通过症状去辨证，症状反应是跟临床实践更近的一条路。要说带着这种理念再回过头看经方的书，“结胸篇”在这个地方就是一个例子。《金匱要略》里最明显，包括后边的“呕吐下利”好多，都有这方面的倾向。比如《金匱要略》里用了另一种方式把所有的妇女病，分三篇写到一块。其它的病凡是在一块儿论述的，都是在临床

反应上有些类似的地方。最明显的比如像“痉湿喝”里的“痉病”，痉病一虚一实，但是都有“抽”的问题；像“奔豚证”，实际上就是“桂枝加桂汤”和“奔豚汤”，比较比较那个方剂，完全是两种不同的病，但是症状反应非常相似，就从症状里辨认就行。假如出现了“气从少腹上冲咽喉”，就以它为核心去辨到底是桂枝汤证，还是奔豚汤证，还是苓桂枣甘汤证。这样辨证是不是很清晰？如果按照现在论述理论的方式，应该把所有病理相同的疾病放在一块儿。

病理相同的疾病，比如桂枝人参汤这个方剂，你把它归到哪一类？如果从药物来看，得把它归到里虚寒里去，把它放到里虚寒里边，就把它的表证给淹没了。特别像古人在竹简上写书的那种条件，很难用更多的语言把“桂枝人参汤证”的表证说清楚，那这本书就变得很冗长了。古人用这种看起来混乱的论述方式反倒是高明的，能用最少的文字说明最多的问题。

“病胁下素有痞”，指的就是患者久有胁下痞的症状，而不是短期内形成的急性结滞性的疾病，早就有这个病。这儿的“痞”与三个泻心汤证里的“痞”不同，跟它是不一样的。

“连在脐旁”。这个字念傍，实际上不如把它读成“旁”，实际上就在肚脐的两侧。

“痛引少腹，入阴筋者”。说的是这种慢性疾病一旦病情恶化到一定程度，不单单患者感觉到胁下痞，而且按它发硬，还有疼痛感，而且这种疼痛感还能一直延伸到腹部的侧部，同时更严重的还能牵引到前阴疼。我们现在客观地说，凡是这类的疾病就比较难治，论述的这种情形比较类似于肝癌、肝硬化、胰腺癌、胰腺炎之类的重病，不太好治。但是，也不能认为这种病就没有治好的希望了，不能把它绝对化了。

做个小结：长期患有胁下痞并且连在脐旁，痛引少腹，入阴筋者，称之为脏结，为难治之证。

伤寒、若吐、若下后、七八日不解（注）热结在里·（经）表里俱热，时时恶风、大渴、舌上干燥而烦、欲饮水数升者、白虎加人参汤主之、（168）

知母六两 石膏一斤碎 甘草二两炙 人参二两 粳米六合

右五味、以水一斗、煮米熟、汤成去滓、温服一升、日三服、（注）此方·立夏后立秋前乃可服·立秋后不可服·正月二月三月尚凛冷·亦不可与服之·与之则呕利而腹痛·○①诸亡血虚家·亦不可与·得之则腹痛下利者②·但可温之·当愈·

注：

1. 《宋本》无此“○”符号。
2. “得之则腹痛下利者”《宋本》作“得之则腹痛。利者”。

胡希恕：太阳伤寒若吐，若下，是皆属误治啊，寻其理，邪热内入而结于里，病七八天不解，热结在里嘛，热实于里它必定要反应到外头来，所以方才我们讲的身无大热，那么如果这个热里实的厉害，它一定蒸于外，所以说表里俱热，身大热，这个白虎汤就是治身大热的，但是它没有到蒸蒸汗出这个地步，时时恶风，就是人体热感觉外边的风寒来袭，也是时时怕风，（音频消失），那么热伤了津液，热就想喝水，再伤了津液他就更想喝水，所以欲饮水数升，就是现在喝几碗才痛快，这个要用白虎加人参汤主之。那么后人也有认为时时恶风，它是有表证，石膏解表是错的，后头它要解释，这个就是白虎汤加人参，他这个人参这个药我们头前讲过，心下痞硬，它是胃虚，胃虚它就不能行津液，我们人身上的津液啊化生于胃，胃虚它的津液就不能行了，它不能纳食了，吃了他也不消化，这个津液当然就不能

补益上来，那么热伤了津液，胃再虚，所以白虎汤加人参，非得恢复胃气，才能恢复津液，古人方子就这样，后人方子就加麦冬、生地了，滋阴，光滋阴胃要是不好也是白搭，所以在白虎汤的基础上，有石膏、知母，这个药很寒啦，足以去热。那么这个津液不生不行啊，所以它加人参，我们看看《伤寒》《金匱》这两个合起来看白虎汤，白虎汤都不渴，可是全是舌干，口舌咽干，那么大渴的时候它都加人参，以致于在用药上它有一个很好的诠释，不是说遇到渴就得滋阴，不是那个情况，那么这个它是有热了，咱们说热盛伤津，达到了相当程度它就大渴，大渴的你在寒药里面加人参鼓舞胃气就行了，这个方子也是这样的，知母、石膏，这个知母啊，也是寒性的药物，它解烦，那么这个白虎汤这个烦的相当厉害了，它祛热的作用也挺强，与石膏并用更能祛寒，可是你用寒药，也顾全胃呀，所以它用甘草、粳米，这个地方都相当好，咱们治病就当大医，用苦寒就是苦寒，用辛温就是辛温，石膏这个药最伤胃了，要是大量吃石膏，不象养胃的法了，那食欲很快就减下来了，但它又用甘草、粳米，粳米，熟了就成了米汤，它起粘化作用，它使胃不受伤，……，所以古人这个方剂啊妙不可言，它不伤胃，那么要是这个大渴饮饮呢，它就要加人参了，它底下解释，所以这个它不是表证。

李冠杰：这个条文在《康平本》里是个顶格的条文。

下面我们解读一下：

在经方理论里边，对“白虎加人参汤证”共有六条论述。其中《金匱要略》里边的一条，实际上是从《伤寒论》条文里边抄过去的一部分，实际上就只剩下《伤寒论》里边的这五条。虽然这五条都是论的白虎加人参汤证，但是各有不同的侧重面。这种论述方式也是经方理论的一大特点，它不把这一个方剂的所有的症状反应都罗列到一块儿，像每次每个方剂后面，我们都跟大家读一下临床统计的症状反应，那些个症状反应就是不分什么情况，或许这个医案里边有那么三五个

症状，另一个医案里边有跟它相同的，也有跟它不同的，而就这样都罗列到一块儿。但是经方这种论述呢，它比较客观，它各有各的侧重，而且这些侧重，几乎都是临床实践当中比较典型的状态。

“伤寒若吐若下后，七八日不解”，这是这个条文的病因部分。关于“白虎加人参汤证”的病因，第26条已经有过一次论述了，论述的是服了桂枝汤以后，大汗出而造成的本方证。本条文里边论述的是：表实证，经过一再地误治以后，而发生的白虎加人参汤证。表证本来应该发汗，吐下都是误治。但是由于误治的方剂不同，或者说是患者的身体状态的不同等等这些因素吧，误治所产生的后果也不同。这个条文论述的就是表实证经过一再的误治发生里热证的情况。

“表里俱热”，别看就四个字，它这里边既有病理状态，又有症状反应。“表里俱热”我们可以把它看作是一个说的表热，一个是里热。我们应该这么理解，这个表热实际上它指的就是体温高，就是发热。因为前边有“伤寒若吐若下后，七八日不解”，所以它本来伤寒就有发热一证，这个发热一直存在。可是我们从白虎加人参汤这个方药里边来看，这个方证里边不存在表证，不应该有表证。

这个发热应该是属于经过了数次的误治以后，人体已经脱离了表证的病理状态了，脱离了表证病理阶段了，已经完全发展为里热了。可是发热这一证始终存在，这个时候这个发热，跟表证的发热存在着质的区别，这时候的发热纯属里热所致，与表证无关。所以这儿的发热应该客观地理解，但是里热呢，就比较好理解了。里热就是指的病理而言，里热别说古人没法测量人体内部的温度，就是现在，现代医学这么先进的手段，他们也不去具体研究体内温度能比体外高多少，有什么意义呀？咱们只是通过病人的症状反应和方药，再加上一些特殊的人体的一些表现，我们把这些相同性质的疾病，规定为属于里热的病理或者里寒的病理。

里热是对条文后边所列举的症状的一个病理界定，同时也是对白

虎加人参汤证的症状反应所做的一个病理界定。

嵌注：“热结在里”，它是对里热的进一步说明。但是大家注意一下：白虎加人参汤证没有结实证。所以说这个“热结在里”，反倒不如后世经常说的那个“郁热在里”更为确切一些。因为没有结滞的，没有那种证候。

“时时恶风”，在白虎加人参汤这五个条文里边，仅仅这个条文里边有这个证，如果我们再从临床资料统计来看，这个症状在白虎加人参汤证当中出现的几率，非常非常的低。一共统计到了 135 个医案，没有一个医案有这样的症状反应。这个地方为什么偏偏又写了这么一个症状呢？本身这个白虎加人参汤证是一个典型的里热证。它以不恶寒，反恶热为常，而且还常常汗出。出现这种证，从条文论述来分析，应该是表证。经过误治以后，都是一些攻法，它必然会造成人偏于虚。那么虚呢，如果里虚则胃肠的功能就会下降，它对水饮的吸收能力就会下降，白虎加人参汤证既有里热又有津虚，这个时候如果它就有表证，表证也没有经过合理治疗，产生里热以后表证消失了。没有表证了它是一种正常的痊愈吗？不是啊，它不是一种正常的痊愈啊。而是人体没有能力在表的这个病理阶段抗争了，所以它就放弃了，是一种没有疾病反应的一种状态。这个时候表的功能，表的状态肯定不是很好，再加上里虚，特别是对津液的吸收不好；又有里热，对津液又造成大量地消耗，这时候可能会出现体表失养的这么一种状况，可能会有点怕冷。

下边“大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升”，这一系列都是白虎加人参汤证的典型的症状反应。它的病理是人体里热严重，机能过于亢奋，致使整体的循环代谢运行都加快。加快的结果就会产生过多的热量，使人体体内温度，超出正常值，过高了。人体内部温度是不允许明显地变化的，它会尽可能地维持正常的内环境，维持它这个正常温度。它就用加快代谢这种方式，将过多的热量散发出来，所以常常

伴有或汗出或小便频数这一类的症状存在。这个“大渴”就在这个基础上，因为体液消耗得太多了，它就出现渴。

“舌上干燥而烦”和“大渴”都是在这种病理状态下发生的。但这是两种不同的症状。“舌上干燥”包括两个方面：一个方面患者主观上自我的感觉，口干口渴得比较重。其实咱们临床当中，倒是你接触接触病人啊，反倒是比较好理解。像有的病人你问他口渴吗，他说又渴又干，早晨醒来以后，嘴里头就跟“木头板”一样，特别干燥，要喝很多的水。另一个方面，在问诊当中医者的感觉，这一类的患者，他的舌质舌苔大多数因为里热严重而出现舌质红啊，舌苔黄啊，而且舌苔燥，比较干。“烦”是因为里热过盛，体内温度高，对人体精神方面的一些影响。这一类患者常常会表现心神不宁，烦躁易怒，难以入睡等这一类的症状。

“欲饮水数升”，这用了一个很形象的描述方法，对这种口渴的严重程度，表述得入木三分。临床当中这一类的患者，有明显地口渴症状。它的病理不外乎上面说的，里热津虚所致。

值得我们注意的是：在临床当中，特别是初学者，常把这里的“口渴”与“五苓散证”的口渴混淆起来，分不清。如果这段时间他比较关注五苓散证的问题，他见了口渴就常常会想到是不是五苓散证。其实这是我们学经方最需要注意的问题，特别是初学者不要单方面看问题。现在我们学的白虎加人参汤证的口渴，如果撇开“口渴”这一个症状，它同时还会有一系列里热的证候：例如脉数，脉洪大，舌红，苔黄，烦躁这一类的症状；可是五苓散证没有那么明显的热象，但五苓散证伴有停饮的症状：比如舌边有齿痕，身上有浮肿，小便不利等。应该比较容易区分的。临床当中，力戒单纯盯在一个证上，一个病上，要全面地看问题。

例如今天有一个患者，得了现在很少得的病，疟疾。治疗几天后，病已去掉百分之七八十了。但是又出现了新的症状是腹痛，患者说前

天晚上发烧了，觉得里热，就吃了一个大苹果，后来大便就偏稀，肚子痛。我们一般想问题，首先想到什么呀？大便稀、腹痛，首先想到的常常会是理中汤。我说你过来我看看，再拿点别的药，前面的药治这个治不了。理中汤我都准备好了，我为什么给他理中汤？因为前边我问他，他说肚子里边凉嗖嗖的，偏寒。过来后我就问他：你哪地方痛，他就说胃痛，我让他指了一下，是胃的左面痛，再仔细看他的舌苔，看他的脉，不对，不是一个理中汤证。这一分析就变了，随着你看到的症状面的加宽，证据增多，有时候一个证就把你的方证全否了。大家对医案特别的热衷，都在讨论医案，而且好多同学都喜欢问我，我在临床当中遇到什么什么病了，如何治疗？其实有时候你们思维的角度和我的不一样，根据你的四诊，我说不定给你一个错误的误导，因为你误导了我。像这个就这样，后来，我分析了这个患者的病症是寒热错杂。虽然有时候他也感到里面烧，肠鸣不明显，他是一个黄连汤证。今天上午十一点左右给的黄连汤，下午就给我电话说，从吃了黄连汤以后，下利再没有出现。

虽然说“白虎加人参汤证”是典型的里热证，但是在临床统计数据当中，这个方证的症状反应里面还会出现四肢逆冷这一类症状的可能，这也就是咱们后世所说的“热深厥亦深”。它的病理实际上是人体的机能亢奋到一定程度以后，它反倒进入一种抑制状态，人体循环系统已经没有能力跟上那么高强度的体内运行了，反倒使它进入一种功能低下的状态。在白虎汤证和白虎加人参汤证重症的阶段，才可能会出现这种情况。这个条文论述的白虎加人参汤证是这个方证里面，一种比较典型、比较常见的表现形式；后边的条文还有，那个就论述了一些特殊的形式。

这个方证的病理：里热津虚。这里的津虚在我们的病理辨证里边就是水虚证。

下面做个小结：伤寒病，如果经吐或下法误治之后，多日不解，

出现了严重的里热证，患者表现为时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升的，为白虎加人参汤主治之证。

这个方剂我们在学习第 26 条时说过，当时说的比较粗，现在我们把重要的给大家说说。这个方剂实际上就是白虎汤的原方加上人参三两，白虎汤这个方剂就是一个典型的清肃里热的方剂。

但值得我们去分析一下的是，白虎汤和调胃承气汤、大承气汤、小承气汤相比之下，白虎汤证没有里实证。

三个承气汤之间的区别，在于里实程度的不同：里实热最严重的是大承气汤证；里实严重，而热证不严重的是小承气汤证；调胃承气汤证是里热严重，但里实不严重，是这样的一个区别。

如果我们从虚实方面，再与栀子豉汤有所比较的话，白虎汤证是里热证，栀子豉汤应该是半表半里有热也伴有里热，它们存在着虚实程度的不同，栀子豉汤证比白虎汤证虚的程度还要明显。

我们从虚实这是一条线，在热证里边，虚得比较重的就是栀子豉汤，其次是白虎汤，再其次是调胃承气汤，再是小承气汤，还有大承气汤。这么一条线，越来实证越重。

人参在这个方剂当中的作用非常简单：就是健胃生津，可以改善胃肠对津液的吸收。实际上就是增强这个胃肠功能。

这个方剂的方后注解当中，有一个地方也挺有意思，煮法：煮米熟汤成，这个“米熟汤成”我们可以把它理解成，以水一斗煮取三升的另一种说法。因为这个方剂当中有粳米，所以用粳米煮熟程度，来控制煎药的时间，比你去控制药液的余量要容易得多，放上药然后加上一斗的水，经常熬米饭嘛，你很容易判断，你知道那个米熟了，这个药也就差不多了。用现在的话说啊，古人在这方面弄得就比较科学，也比较人性化。

方后注解之后，有一段后人所加的注解内容，应该是王叔和所加。这也不是随便这么一说的，至少我们有两个依据：一个是《康平本》、

《宋本》当中都有这个内容，说明这些内容必然是王叔和或者是王叔和之前的注家所加；第二，这个注解内容在学术观点上与“伤寒例”里边降两字格排版的内容一脉相承，应该是出自一人之手。但我们从目前所知道的史料来看，在王叔和之前，有可能往这本书里边加注解的作者就非常少了，就是王叔和张仲景，就这么两个人，所以这个内容是王叔和所做的可能性非常大。

从这个注解内容分析，我们可明显的看出这个作者在理论上与经方理论不是一个体系，这个作者在学术上偏于玄虚，他是将中医理论当中那些玄虚的内容，引进经方理论的鼻祖。我说这个在后边都有根据的。

注解内容：“此方立夏后立秋前乃可服，立秋后不可服，正月二月三月尚凛冷，亦不可与服之，与之则呕逆而腹痛；诸亡血虚家亦不可与，得之则腹痛；下利者但可温之，当愈”。我们不去分析字面上的东西，这些东西非常好理解。这个注解的前半部分纯属无稽之谈。在这个书的原文的论述当中，特别是那些顶格的条文，你看《伤寒论》和《金匱要略》当中，根本就不存在某方证的发生或某个方剂的应用与季节有任何关系。这不是经方里边的东西，这是其一。在经方理论里边这个方剂能否应用，全凭是不是符合经方的治疗原则和方证是否相应，这是最根本的。你只要符合这个，跟季节无关。

我们从另一个方面，从临床统计数据看，白虎加人参汤一共统计到了 135 个医案。这 135 个医案里边有季节记载的 77 例，其中春季用白虎加人参汤的是 8 例、夏季是 36 例、秋季是 17 例、冬季是 16 例。按着这个数字简单地分析的话，只能说夏季发病率偏高，但是绝对没有秋季、冬季或春季不发生白虎加人参汤证或者说不可应用这个方剂的这种结论，根本就不成立。如果深入分析的话，从宋朝一直到现在，这个书里边始终有这一部分内容，凡是用这个方剂的，哪一个医家没有看过这本书。看了这本书以后，会不会对他应用这个方子有

影响啊？大家想想，方剂里边给你明确地说了，立夏以后立秋以前才可以用，其他的季节不可以用。会不会有一些医家在实际临床当中，冬天明明看到这个患者是个白虎加人参汤证，但是他不敢用白虎加人参汤，用了其他的方剂。有没有这种可能性？这种可能性非常大。

这一段注解文字在《宋本》里边不是注解文字啊，这都纳入正文了。如果我们考虑到这段文字的误导作用的话，恐怕我们统计医案当中，其他季节的记载还会高一些。那实际上四个季节的发病率、应用率，没有太大的区别。所以说这个注解，我刚才为什么说它是无稽之谈就在这，它跟临床根本就不能接轨。它带有浓厚地这种主观臆想的色彩。

如果从这一点上推而广之，深入地去思考的话，很多问题会让你触目惊心！它的理论是哪来的？这不是王叔和自己造的，他也是有根有据的！这些东西都不对，跟临床没法接轨。

我记得有一次，两个派别在争论，一个派别说：五运六气理论非常深奥、非常正确。持反对意见的人提出一个问题来：按照五运六气的这种推算，六十年整整一个周期，换句话说，如果一个1岁的儿童和一个61岁的老人，就随时有可能得相同的病，要服用相同的方子，这就是不可思议的问题了。

就是说有些谬误的东西，说起来是夸夸其谈，让人感觉很有道理，如果你稍微转换一下角度，它就经不起推敲。凡是来自于临床实践的，像经方的这些东西，它经得起这种推敲。我们也可以这么想，之所以王叔和本人把这样的内容加到经方的书里面，说明他本人，不只一次的有这样的临床经验。原因是什么？毕竟因为他本身对经方理论理解得不深、不透、不正确，所以临床当中难免会有辨证不准确的时候。可能病人就不是一个单纯的白虎加人参汤证，还有别的证，因为辨的不够准确，给人家吃了白虎加人参汤以后，造成一些不良的后果，这就把它写到书里面了，没经过详细地推敲和论证。

关于这个问题，我个人经验，十冬腊月给白虎汤或白虎加人参汤的，患者吃了以后和其它季节闹这个病，吃这个药相比，疗效没有任何区别，疗效一样好。

我记得最明显的一次，一个七十多岁的老人，他的姑娘到我这儿来，说她父亲能吃能喝能尿，到医院里首先查尿（血）糖，结果尿（血）糖不高，医院没辙了，因为定不了糖尿病，就不能给他吃降糖药，就把他给推出来。后来就找到我，我说你让他过来看看吧，她说你看这么大的雪，家里也没车，怎么能过来。我说这样吧，我在电话上问问，就这样，我就给他白虎加人参汤。那时就是十冬腊月，天很冷，给了他五天的药。药还没有吃完，病人的症状就全部消失了。

伤寒、无大热、口燥渴、心烦背微恶寒者、白虎加人参汤主之、（169）

胡希恕：伤寒外边没有汗，同时外边也无大热，但里头有热，口燥渴，口舌干燥而且渴，一渴它就加人参，心烦得厉害，背微恶寒，它胃要有热啊，当胃的这个部位，它也微恶寒，所以后背当胃的部位它恶寒，这是一个辨证常有的情况，如果胃有停水，背恶寒，背寒冷如掌大，如果有热呢，外边特别热，它也感觉外边风来袭，它外边也恶寒，一有热它口要燥渴，有寒口中和，所以我们后头要讲的，这个有寒，所以这个也好辨，但这个地方就要注意，这个当然也用白虎汤加人参主之，它渴嘛。

李冠杰：这是一个顶格的条文。

下面解读一下：

“伤寒”在这个条文中，可以做两种理解：一个是白虎加人参汤证可能是由伤寒发展而来，得了伤寒以后，不经过治疗，表证的阶段越过，出现了里热，这是其一；第二，还可以理解成这个方证中，可

能会有伤寒病的某些特征性的症状反应，比方发热无汗。这个在下一条里就有。

“无大热”，这是这条里面论述的一个重点。为什么？因为这个方证就是里热严重，常表现为身热汗出，以这个为基本的特征性的症状反应。但是在临床当中，也有不怎么发热的，或者发热不明显，发热不严重的，这类的情况也有。

后面的“背微恶寒”，跟“无大热”有一定的内在联系。这个条文实际上论述的是白虎加人参汤证当中，偏于里虚的这么一种情况。也就是胃功能低下。不单单是因为人体津液虚，以至于达不到身热汗出的程度，而且还出现了与胃相对后背部位“微恶寒”的感觉。实际上可以理解成“热深厥亦深”的轻度反应，只是表现为后背的轻微感觉，到不了四肢厥冷那种程度。

“口燥渴，心烦”，这是白虎加人参汤证的典型症状反应。在这个条文里，是常见证或者是必见证。如果没有这个证的话，那白虎加人参汤证也就不能成立了。如果病人表现为无大热，背微恶寒，又没有口渴什么的，就不能认为它是白虎加人参汤证。

那么值得注意的是，条文所论述的“背微恶寒”这个症状，在临床统计资料 135 个医案当中，只有两个医案有这个症状反应。说明什么？说明这个症状在本方证当中，出现的频率不高，非常低。也佐证了条文论述的，是白虎加人参汤证比较特殊的一种情况。重点不在于向你交待“口燥渴、心烦”；交代的重点是：人有时候也会出现“无大热、背微恶寒”的这种情况。

下边做个小结：貌似伤寒，但表现为无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒的，为白虎加人参汤的主治之证。

伤寒、脉浮、发热无汗、（注）其表不解者・不可与白虎汤・（经）

渴欲饮水、无表证者、白虎加人参汤主之、（170）

胡希恕：它怕你里头加这个，背微恶寒，时时恶风，怕你认为是表证，表证吃白虎汤那是不行的，所以在这里特别提出这一条，伤寒，脉浮，脉浮它表未解嘛，发热又无汗，其表不解者，就是这个情况，它是表不解嘛，不可与白虎汤，总得渴饮水，它内热有了，而且没有表证，这才可用白虎加人参汤，不然的话不要妄用，它不是解表，所以后世把石膏打入解表药，说它是辛寒，给它加个辣，谁说石膏辣，它是甘寒，它不辣，你要达到解表了，就得辣，不辣不出汗啊，所以它又解表，哪有那个事啊，所以特意出这条，就是让你注意，它外边恶寒就是由于有热，恶风以致于背微恶寒，也不是恶的厉害，没有表证。有表证不能用它，还得先解表，以后你加石膏可以，有石膏证也可以加入，比方用葛根汤加石膏，或者是我们刚才讲的麻杏石甘汤，越婢汤，有的是，大青龙，它是无汗出而烦躁者，那个里头有解表药加石膏，你不用解表药只是用白虎汤，那不行，所以这个方证啊，……一个方剂有它一定的适应范围，就是说它的证候，换句话说，你到治病的时候，往往弄错了，这个治病啊，治对了，要是这个病严重，好的面啊不明显，但是见好，弄错了，立竿见影，马上就好，所以这个治病啊，兴对不兴错，错了就出大问题，你看头前讲的那个……，内有停饮，晕眩，那么这个病吃利尿药就好，你一误再误，弄的人痿废不能行动，那都是当大夫的责任了。

李冠杰：这个条文在《康平本》上也是个顶格条文。

下面解读一下。

“伤寒”，在本条文当中，与前第 169 条的“伤寒”可以做同样的理解。就是指的由伤寒发展而来或者是方证当中包括的某些伤寒症状。

“脉浮，发热无汗”，这与太阳伤寒表证的症状反应，非常相似。关键在于条文的后面有一个“无表证”，那么无表证，这个“脉浮”

跟“脉浮紧”有一点区别；或者应该还有“不恶寒，但恶热”。如果像这种情况，再有“恶寒”的话，那表证存在的可能性就非常大。所以，很有可能还会有“不恶寒，但恶热”这一类的症状。只有这样，才能确认它“无表证”。

“渴欲饮水”，这个说的也是“白虎加人参汤证”的一种简述。之所以在这儿讲这个证，除了条文里面的“无汗”以外，其他“白虎加人参汤证”的症状反应，都包括在其中了。像这个“渴欲饮水”等一些热证，里面都有，这是一个简述。

那么这一条，论述的实际是“白虎加人参汤证”另外的一种比较特殊的表现形式。就是因为有“无汗”这一证，与正常的“白虎加人参汤证”的常见证不同，所以在这加以论述。或者换个说法：白虎加人参汤证有时也会表现为发热无汗。但是在这个时候，如果出现这种情况，你要认真地去辨认一下有没有表证的存在，只有确定了没有表证的存在，才可以应用这个方剂。

后面的“其表不解，不可与白虎汤”，这是一个嵌注内容。它重在强调经方理论当中，“先解表后攻里”的治疗原则也适用于本方证。在经方理论当中，如果既有表证，又有白虎汤证的话，可以同步治疗的：比如说大青龙汤证、麻杏石甘汤证、越婢汤证、小青龙加石膏汤证、厚朴麻黄汤证，这些都是治疗既有表证，又有里热的，一样可以应用。这个注解恐怕也不是特别贴切。

下边做个小结：本为伤寒，但是症状表现为脉浮，发热无汗，渴欲饮水，无表证的，为白虎加人参汤主治之证。

大阳少阳并病、心下硬、颈项强而眩者、当刺大椎、肺俞、肝俞、慎勿下之、（171）

胡希恕：太阳少阳并病就是先得的太阳病，这个病传入半表半里，

又发生少阳病，而太阳病还不罢，这叫做并病，心下硬，这是我们前面讲的人参证，这是小柴胡汤证，心下痞硬，不可吃泻药，吃泻药下利不止者死，后头阳明病篇就有了，它是胃虚嘛，颈，我们这个脖子两侧是颈，后面是项，颈强是少阳证，眩是指目眩，指少阳证，所以这个太少证候俱备，它叫太阳少阳并病，那么这个柴胡证不太完善，还不太完备，那么可以用针刺之法，当刺大椎、肺俞、肝俞诸穴，那么这个就去胸腹的邪热之气，我们吃小柴胡汤也是为这个，它就是祛这个胸腹邪热，慎勿下之，这个病啊，万万不要吃泻药，因为太阳也忌下，少阳更忌下，尤其是这个心下硬，你不要看它是个实证，这个心下硬，纯粹是胃虚，要当实证下之非坏不可，所以搁个慎勿下之，当然这个病我们要使小柴胡汤是可以的，这也就说明，少阳病而现柴胡汤证，柴胡证不太明显，那么有用针刺之法，大椎、肺俞、肝俞都可以刺，这个就祛胸腹间的邪热之气。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。

这条论述的是由表证进一步发展为半表半里证，而且表证还没有完全解除的一种情况，也就是条文里说的“太阳少阳并病”。

“心下硬”。仅仅说心下硬，而没有说心下硬满，没有言“满”，那么这个“心下硬”应该是指的里虚证的心下痞硬。

“颈项强”，是太阳少阳同病的一个症状反应。但是，从一个颈部的症状来确定疾病的依据，是不太合适的。“项强”这类的症状常常见于太阳病中，项背强几几，或者说头项强痛，都跟颈后部的关系比较密切，它出现反应的机会比较多；“颈”在此处指的是颈部的两侧，多见于少阳病。这一点，近代医家在临床中有这样的经验：以颈部两侧部位的肌肉承受按压的敏感程度为依据，来作为小柴胡汤证应用的指征之一。据说准确率比较高。我在临床中有时也会试一试，也不是每一个小柴胡汤证的患者，颈部两侧的肌肉对于按压都那么敏感，有时候第一次捏，患者可能反应不太强烈，第二次捏的时候病人

感觉打怵，不想让你捏，非常敏感。应该是有这一方面的因素存在。

“眩”，应该把它看做少阳病里面口苦、咽干、目眩的那个眩。

“当刺大椎，肺俞，肝俞”。因为从它的述证看，表证、半表半里证都不够典型，这个条文的作者就给出了一个用针刺治疗的办法，我们可以做参考。

“慎勿下之”。这一句话还是挺重要的，再次强调了经方理论里太阳病、少阳病皆不可使用下法的治疗原则。

做个小结：太阳少阳并病，如果表现心下硬，颈项强而眩的，可采用针刺大椎，肺俞，肝俞的方法治疗，切不可使用下法。

大阳与少阳合病、自下利者、与黄芩汤、若呕者、黄芩加半夏生姜汤主之、（172）

黄芩汤^①

注：《宋本》作“黄芩汤方”。

黄芩三两 芍药二两 甘草二两炙 大枣十二枚擘

右四味、以水一斗、煮取三升、去滓温服一升、（注）日再·夜一服·

黄芩加半夏生姜汤^①

注：《宋本》作“黄芩加半夏生姜汤方”。

黄芩三两 芍药二两 甘草二两炙 大枣十二枚擘 半夏半升洗 生姜一两半切

右六味、以水一斗、煮取三升、去滓温服一升、（注）日再·夜一服·

胡希恕：太阳与少阳合病者，那么就指有太阳病的证候，这个太

阳病的证候也不过是脉浮，发热而已。它并不恶寒，要真正有恶寒啊，那还是要用葛根汤，它说有，那么所谓少阳病呢，当然有口苦咽干这类情况，那么这两种病同时发作者，谓之合病，合病与并病的差异啊就在这么一点，先有太阳病而后有少阳病，就是由太阳转属为少阳了，这个叫做并病，前一个病并到后面这个病而发病，这个合病呢既有太阳病的证候，又有少阳病的证候，叫同时发作，这个不是相传，叫合病，那么这种合病，自下利者，可与黄芩汤，那么这个证候呢，总而言之有热，太阳少阳都是一个阳热的证候，就是既有表热，又有半表半里之热，它是这种情况，但是太阳病决不明显，要是明显的，虽然有自下利，它也要用葛根汤，要么用葛根汤来加，所以这个我们必须分清了，刚才在那个协热利里讲了，它那个也是表里不解，这个也是表里不解，可是这个是太阳从少阳说的，有些口苦，有热象，半表半里也有热象，也有表热的情况，但它不是纯粹表证，要是纯粹表证，得先解表，那么要用葛根汤，那么这个黄芩汤，这个下利，也治热利，这种热利就是痢疾了，没有明显的表证，但是有发热，口苦，这一类的啊也给起名叫太阳与少阳合病，一发作就这样，那么这个情况有用黄芩汤的机会，这个黄芩汤啊，它下利，腹痛，它有芍药啊，那么这个它以黄芩为主药，它也是祛热的，烦躁腹痛而下利者，可以用这种方剂，我们现在用的白头翁汤，它那个比这个更凶，它这个排泄物感觉烫呀，那你吃黄芩汤就不如吃白头翁汤了，那个后头要讲到，到厥阴篇就讲到，这个以腹痛为主，腹痛有些烦，这种痢疾，可以用黄芩汤，有热，如果要是呕，还要加半夏、生姜，就是小半夏汤，加小半夏汤，就是止呕，那么黄芩汤就是黄芩、芍药、甘草和大枣，那么芍药甘草汤就治肚子痛，黄芩就是去热，解烦，大枣是安中的药，也治肚子疼，所以这个药治肚子疼，热利腹痛，但是要是下重，里急后重的样子，这个不行，起码要加大黄，那就……白头翁加大黄，黄芩加半夏生姜呢，就是上边黄芩汤加上治呕吐的半夏再加生姜。

李冠杰：这是个顶格的条文。

因为这个条文的论述过于简略，要比较全面地理解“黄芩汤证”，不但要解读条文的论述，还要结合方药和临床统计资料，并且对一些类方进行鉴别以后，才可能在临床当中把它用好。

“太阳少阳合病”，如果仅仅从字面上理解的话，则是论述的黄芩汤的病理。这是两大类疾病类型，合病与上面的并病有一点区别，合病：就是两种或两种以上不同类型的疾病同时发病的时候，可以称之为合病。

我们从方药的角度来分析这个方证的病理，黄芩汤证不应该有表证存在，它的方剂里面也没有解表的药。这里的太阳病我们该怎么理解它呢？这个条文里面论述得比较简，列举的症状非常得少，我们就有必要参照临床统计资料。在临床统计资料当中，这个方证有时候会出现发热、恶寒的这些证状，“太阳少阳合病”中的“太阳病”，应该有这方面的含义，它就是指这个方剂里面有时会出现类似太阳病的症状。少阳病在这个方证里面，在病理上主要的表现为半表半里的热证。

“自下利者”是这个条文列举的唯一的的一个症状，单纯的下利，有时候它是寒性下利，比如说理中汤证；有时候是热性下利。这里仅仅说了自下利者，还需要对下利进一步地定性。我们看一下方药，再看一下临床统计资料，临床当中的症状表现，全面看一下，这个下利应该是热性下利无疑。如果说是热性下利的话，就势必还会带来另一个问题，热性下利本身就是里热证，所以这个方剂当中应该有里热证的因素存在。

黄芩汤证的病理，按照条文的定性为太阳少阳合病；但是如果我们按照疾病的症状反应和方药进行分析，它应该是少阳病与阳明病同病。之所以这个条文冠以太阳病，它跟其他的少阳病和阳明病不太相同的一个地方，就是有时候表现出来比较典型的表证的症状反应。

在临床统计资料当中、后世的临床医案里边就有这样的表现：就是发热、恶寒，应该说比较典型的表证的症状了。再加上本身是一个热证，往往脉也会现一种浮数的脉，也比较类似于表证。

但是方中却没有一味是解表药。客观地理解这个条文的话，这个条文论述的就是一种比较特殊的情况。特殊在没有表证的病理，反倒是出现了类似表证的症状反应，所以条文就特别强调这一点，免得让你把它当做真正的太阳病来治。我们这么理解呢，反倒是对这个方剂的应用，比较客观、也比较准确。

从这个地方我们可以看到古人，在对这一类问题的认识上，实际态度也是比较客观的。为什么？比如这个条文，本身前后就矛盾，说有太阳病，但是药物里边却没有一味解表药。有写这样的经典的水平的人，不会犯这么简单的错误。所以说这个地方，我们可以理解成他这是有意强调这一方面。

综上所述，黄芩汤证的病理：应该是半表半里的热证合并里热证与血虚证。

这儿，怎么又冒出一个血虚证来？咱们在方解当中呢，顺便就说了。

下面做个小结：少阳与阳明合病，同时伴有表证的症状反应，主要表现为自下利的，可用黄芩汤治疗；如果同时还有呕的，为黄芩加半夏生姜汤主治之证。

实际上真正在临床当中用这个方剂，还会碰到一些很实际的问题，比如说：这个热利和白头翁汤的热利有什么区别？和葛根芩连汤的热利有什么区别？如果你本身划不清界限，何谈应用啊？肯定用不好！

深入地分析分析这个方剂。这个方子一共由四味药组成：黄芩、芍药、甘草、大枣。

黄芩是主药，在这个方剂当中，它既能去半表半里的热，又能去

里热，同时还有止利的作用（在寒性药里，一个是黄芩、一个黄连，对下利，但是得是热利，都有治疗作用）。芍药、甘草是等量的，相当于一个芍药甘草汤。所以这个方剂的适应证里边，就可能存在、或者常常存在着因为血虚而造成的拘挛痛（是腹痛）。在这个方剂当中，腹痛出现的几率非常高。

大枣在方剂当中，有安中去饮的作用，同时对于腹痛也有一定的治疗作用。

这四味药物合在一起，就可以治疗因为半表半里的热证和里热证同病，并伴有一定的血虚证的这种病理状态下，造成的以下利为主要症状的这种疾病。

我们再看看临床统计资料：这个方证里边，腹痛出现的几率也是非常高的，跟药的药性也是相吻合的。整个方剂里边，有三味药都与这种因拘挛造成的腹痛都有关。

后边的方剂黄芩加半夏生姜汤，就没必要讨论得太多了，本身就是黄芩汤的基础上，因为有呕吐这样的症状，加了半夏和生姜。这两味药咱们前边也说过很多次了，都是健胃、祛饮、止呕的作用。凡是黄芩汤证，偏于胃虚停饮而见到有呕吐的这种患者呢，就可以用这个方剂。

这个方剂的症状表现比较简单一些，我需要跟大家挑重点说一说，出现频率最高的就是下利，其次就是腹痛，还有里急后重、发热、恶寒。这儿一共统计到了五个出现频率比较高的症状，其中就包括了发热、恶寒。所以这个条文里边说是个太阳病，也是有意而为之。

另外，需要跟大家说明的就是这个黄芩汤的“下利”，有的资料这样介绍它，包括赤白利，赤多白少。这 15 例下利当中有 8 例出现这种情况，这个明显就是一种“热利”的那种表现。另外还有口苦、咽干、目眩这一类的情况，但是比较少，但是跟条文论述的也相吻合，就是一个半表半里证。

舌质：以淡白为主，有红舌、紫绛舌、少津的舌。但是从统计资料上看，没有明显的规律可循。

舌苔：以黄苔为主，其次是薄苔，白苔和黑苔。

脉象：数脉是出现频率比较高的，然后是弦脉、滑脉、沉脉。

在现代应用方面：多集中在一些肠道疾病，比方说痢疾这一类的疾病方面。

关于这个方证咱们做一个延伸。由于这个黄芩汤证有关的论述在经方理论里边就有这么一条，仅仅这一条，而且还非常得简略。同时黄芩汤证在临床表现上，与它病理比较类似的方剂的症状表现，有许多类似的地方，在临床当中就需要我们加以鉴别。黄芩汤证与白头翁汤证和葛根芩连汤证，无论是在病理上，还是在疾病的症状反应上，都比较类似。但是这三个方子的组成却差别比较大。所以有必要对它们先做一个粗浅的鉴别：

黄芩汤与葛根芩连汤相比较，在表证或者说类似于表证的症状反应上，虽然都可能出现发热恶寒这样的症状，但是黄芩汤证没有葛根芩连汤证的表证那么典型。

与白头翁汤证相比较，虽然都是以热利为主，但是黄芩汤证的热利的证候明显就不如白头翁汤证的这个里热的证候这个严重，咱们从药上就能看出来。实际临床统计结果也是这样的。

说到这个呢还都是一些原则，我在整理这个资料的时候，发现了一个很好的鉴别点，在这跟大家介绍一下，这三个方剂在临床当中大便的形态上存在着明显得差异，可以作为一个重要的鉴别指征：黄芩汤证的下利多呈现大便如蛋花样；白头翁汤证的下利，呈现为赤白痢，带有脓血，这明显热证比较重了；葛根芩连汤证的下利，多呈现为水样便，便后有粘液有脓血的样子。这个鉴别点反倒是比较具体，也比较容易掌握。

如果我们在这一点上深入思考的话，可以带出一个非常重要的问

题来。在近代就有临床经验比较丰富的老中医，他在临床当中就喜欢用肉眼去鉴别病人的大便。大家想想，人体的大便，不仅仅排出来的是消化完了以后，剩余的那些不可消化的食物，不是，实际上它携带着全身所有的代谢过程当中，无法通过小便排泄的那些废物，几乎全部要通过大便排出来。除了汗液、小便能排出来的那些东西，其他的都需要在大便里边排出来。所以说大便常常可以反映人体的整体的身体状态。但是现在呢，尽管现代医学对这方面研究得比较具体，可是很少有人站到中医的角度上，为了找用药的证据，特别是用中药的证据而去研究大便。像这样的研究，现在还没见过谁有这方面的报道。

黄芩加半夏生姜汤就不具体地说了。

伤寒、胸中有热、胃中有邪气、腹中痛欲呕吐者、黄连汤主之、（173）

黄连三两 甘草三两炙 干姜三两 桂枝三两去皮 人参二两 半夏半升洗 大枣十二枚擘

右七味、以水一斗、煮取六升、去滓、温服、（注）昼三夜

二·昼三夜二疑非仲景法①

注：《宋本》“温服”之后为“昼三夜二，疑非仲景方”。

胡希恕：胸中有热，那么就有热邪了，而胃中有邪气，这个邪气指的水饮，热邪与水气相互激动，所以它腹中痛，就是里头这个水饮为热所激动，它腹中痛，而且欲呕吐，胃要不停水它不吐的，一般吐呀都是胃中停水的时候多，但是没有热的刺激还好些，要有热非吐不可，咱们讲小柴胡汤，邪高痛下，故使呕也，它有热邪，他激动水，它更容易呕吐，黄连汤主之，这个黄连与黄芩，黄连有治肚子痛的作用，黄芩没有，上面黄芩汤所以治腹痛，他有芍药大枣的关系，那么

这个治腹痛与黄连有关系，同时治胸中烦热呀，也比黄芩好，这个凡是在临床上用三个泻心汤，人颜面潮红呀，大致黄连用的多，黄芩也有这种情况，但不如黄连更明显，所以这个方以黄连为主，特别提出胸中有热。咱们那么黄连上清丸呀，清上边的热，这个热往上边涌，所以颜面潮红呀，胸中也特别觉着烦热，那么另外要还没水，它不会呕吐的，它如果激动水，下面腹痛，这个药也治痢疾，也治下利，同时热来上头，寒饮也往上走，那么也容易呕吐的，这个方子与头前讲的泻心汤差不多。也有干姜、甘草、人参、半夏、大枣，与头前讲的甘草泻心汤差不多的，不过没有黄芩，又加了个桂枝，这个桂枝治往上冲，他觉得胸中有热，也有往上冲，往上冲就得用桂枝镇冲气而降逆，所以给桂枝。这里没说到下利，他说呕吐，冲逆的太凶，就是上而不下，没有到下利，但是这个方子也治下利，如果要下利，同时有呕吐，上边烦热得厉害，这个方子就可用。头前那个泻心汤黄连量非常轻，一两，另有黄芩三两。这个里头是黄连加重了，他把黄芩去了。那么也就是上边烦热的厉害，同时有气上冲的这种甘草泻心汤证，可以用这个方子，它所不同的，那个没有桂枝，没有气上冲得那么凶，这个气上冲的厉害，同时那个黄连少，它烦的较轻，在甘草泻心汤、生姜泻心汤、半夏泻心汤都没有提到胸中有热，有热就烦，那个烦较轻，那么这个也有心下痞硬，有人参啊，你看看，它也有这个，不过在这没提，因为头前这个方剂很多了，你自己可以参考了，所以这个方子的应用与甘草泻心汤，心下痞硬，腹中雷鸣，这个也可以有腹中雷鸣，也有干姜半夏，也去水，所不同的，它是治甘草泻心汤证气上冲而烦热甚者就行了，所以这个方剂连我们的那个甘草泻心汤、生姜泻心汤，半夏泻心汤是大同小异，也是呕吐，也是下痢，那么这个它是以烦为甚，它后面这个方后语有些错了，右七味，以水一斗，煮取六升，去滓，温服，这个错了，它这个小柴胡汤与这个几个泻心全是煮取六升的，它去滓还要煎，取三升温服一升，日三服，它应该这样，

所以它这个去滓温服，昼三夜二，这是错了，这个应该改为再煮取三升，温服一升，日三服，这就对了，但是这个说法决不是他的说法，它与前后不一致，大概玉函经就是这样的，再煮取三升，温服一升，日三服这个可以把它改了，咱们今天就讲到这儿，回去你们也看一看，把这个太阳病啊三章合到一起，下一次呀，咱们做个总结，做总结第一个主要的，我们要把他的书排开，看看他的方法方式是什么。对于太阳病在他这个书上怎么讲的，我们应该怎样认识，那么它哪一些是治太阳病的，哪一些不是治太阳病的，它这全书的精神，太阳病讲的特别的多，比如方才我说的，它讲的是表证，这个病是转瞬万变，它不老在表，它也要传半表半里，也要传里，它本来是讲的阳证，它也可以转化为阴证，尤其经过治疗，所以仲景这一篇，这些关系，他都讲到这一篇了，不是说这里所讲的全是太阳病，它讲太阳病近东西也有。你象太阳病依法当发汗，是发汗解表的方剂，都属于太阳病的范畴的，其它不是的，所以有些注家见这一篇都是太阳病，他一扑救是的，他就拿出去了，有的书都是这样的，把这个书改得乱七八糟的，那么讲到这里头也可以吧，所以表证与里证，表证与半表半里，无论是证和治，这个规律法则，它都讲到太阳篇了，在旁一篇就不再这么详细了，在这篇里头讲的很多了，你象头前的合方啊，在这里都讲了，后头就不讲了，你看方才讲的桂枝人参汤，他也是合方，他就不提了，它因为头前有，麻黄桂枝二越婢一汤，麻黄桂枝各半汤呀，他那个合方的方法，合方的形式都讲了，后头不讲了，不是一不讲就没有了，还有的是，你看书应该看懂了。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边也是一个顶格的条文。

“伤寒”在这儿呢，应当就是指的表证而言，因为这个方剂当中含有一个桂枝甘草汤方。如果说在这个方证的基础上同时又存在表证的话，那么也应该是这个方证所治疗的范畴；另外还有一层意思，这个方证有可能是由表证发展而来的。表证失治或者误治，也可能发展

为这一类的疾病。

“胸中有热”，是指的患者出现了胸中烦热等黄连证。同时呢，也是对黄连汤证有半表半里证的病理，所做出的一个论述。所以说，一旦提高到病理的这个角度，那么这个“热”就不应该是仅仅局限在胸部有烦热的这种现象，还应该存在着一系列的：脉数、舌红、苔黄，还应该有这一类的热象。但是这个方剂呢，寒热错杂。其他热证，肯定没有患者自我感觉胸中有热来得这么明确。

“胃中有邪气”，这也算是一个症状吧。关于这个述证，历代的注家都是归于“里寒”。这个方剂有一些温里的药，所以说“胃中有邪气”是里有寒邪，或者有里饮，或者即有寒又有饮。“胃中有邪气”就是指的这一类的东西。从药物的方剂组成看，也确实确实有温里的药。

但是，我们整体地来看经方方证当中，对于这一类的疾病症状，论述得不少。比如：半夏泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤，温里的药物跟这个方剂几乎是一样的。而且还都是有半表半里的热又有里寒，都是一样的病理，但是没有一个论述的是“胃中有邪气”。只有这个方证用了“胃中有邪气”，这必定是有原因的。如果我们仅从字面上看，恐怕很难看出其中的原委。

如果我们结合临床实践，反倒是比较容易理解。前几天恰恰我就碰到了这样一个病人。这个病人主诉就是腹泻，大便呈水样便，他有轻微的肠鸣；脉弦细偏数；舌质红；苔白厚间黄，也就是说上面有一层黄的。最为典型的症状反应是什么呢？他腹痛胃疼，除了下利以外，他这个胃疼是一个比较明显的症状。但是他这个胃疼，一个是从疼痛的部位上，是痛无定处，有时候是在胃的左侧，有时候就是在胃部，有时候还会稍微偏下一点；而且这种疼痛，发作过程也比较特殊，呈现出阵发性，一阵一阵的疼。这一阵一阵的疼还是有原因的，常常跟一些他做的事儿有关，很规律。后来他发现这个规律：大便的时候疼，

小便的时候也疼，有时候吃东西也疼，吃药的时候也疼。这个吃药呀，这里边需要跟大家说明一下：由于病人在发这个病前两天时候得了疟疾。每天定时发热、定时恶寒。我就给他柴胡桂枝干姜汤，第二天就去了大概七八成了，第三天疟疾基本上就好了，然后就出现了这个病。但是柴胡桂枝干姜汤，我还让他喝着。根据辨证他就是这个方证，我就给他黄连汤，吃了以后，他吃这个方剂就不痛。吃柴胡桂枝干姜汤，喝到肚子里边马上疼。黄连汤一剂，喝了一次，下利就止了。又喝了两天，腹痛就彻底消失了。

通过这一个病例，我们能够从中感觉到：为什么仅仅只对这个方剂说“胃中有邪气”？因为，这个方药里面：黄连去半表半里热，也可以去里热，同时可以治腹痛，这种疼痛方式跟黄连有一定的关系，这是其一。另外呢，方药里面有桂枝，说明有气上冲的因素存在，所以说在这种寒热错杂，同时又有气上冲的病理条件下，就极易出现这种反常的疼痛。这个条文里面用了“胃中有邪气”，大家这个时候再去体悟，这个论述得非常好。如果没有临床这样的经验呀，你就会觉得，这不是弄得也挺玄吗？是吧！其实不是那么回事。大家体悟体悟，是不是有这样的味道在这里边。当然就凭这么一个案例，因为其他的案例呀，都记录不了这么详细，只有我们自己在临床当中去体悟，你才能感觉得比较深。假如我们自己身上得上这么一个病的话，你体悟还会更深一些。

“欲呕吐”，在本方证中有两个方面的原因：一个是有里虚寒，胃肠功能低下所致的里有饮，导致的呕吐；再一个就是有气上冲的因素存在，胃气上逆，造成的这么一个呕吐。

黄连汤的适应证，在临床当中除了条文论述的这些症状以外，出现频率比较高的还有：腹泻，胃脘痞满，食欲不振。但是条文就都省略了。

这个方剂的病理是：半表半里热证合并里虚寒证，兼气逆证，或

者还兼有表虚证。

下面做个小结：或有表证，或因表证发展而来，患者表现为胸中有热，常伴有不同寻常的腹中痛，欲呕吐的，为黄连汤主治之证。

这个方子有七位药组成：黄连、甘草、干姜、桂枝、人参、半夏、大枣。这个方子实际上就是半夏泻心汤去了黄芩，加了桂枝三两；黄连由一两加到了三两；人参减了一两，成了二两。这个方剂当中所有的药物呢，我们前边做过不止一次地讨论了，那么就不去一味一味地分析了。

刚才我们说了：除了条文的论述之外，在临床当中还会有一些其他的症状，大多数症状与半夏泻心汤之类的三个泻心汤的症状比较近似。所不同的就是“胃中有邪气，腹中痛”，而且“腹中痛”在三个泻心汤证里边也可能存在，但是疼痛的程度和疼痛的方式有一定的区别。所以这个地方用的是“胃中有邪气”。

这个方后注：“右七味，以水一斗，煮取六升，去滓温服”。这是顶格的内容，后边又加了一个附注：“昼三夜二”。这个“昼三夜二”的边上，又挎了一个旁注：“昼三夜二，疑非仲景法”。

可是到了《宋本》里面，除了把正文以后的文字调整以外，改了一个字，“疑非仲景法”又改成了“疑非仲景方”。

那么差别在哪儿呢？首先，这个“昼三夜二服”，加的本身就是一个多余的，加错了。为什么？看看这个方剂，这个方剂的方药，跟半夏泻心汤、甘草泻心汤三个泻心汤非常接近，而且，煎煮方法也是一样的。上面写的很明白：“以水一斗煮取六升，去滓”，到这个地方，跟三个泻心汤是一模一样的，后边必定还会有：“去滓，再煮取三升”，应该是这个样子的。但是，这个地方估计就是出现残简了，后边还有“温服”这两个字。然后，就写了个“昼三夜二服”。在经方里边，这种服法非常少，不符合经方的规律。

更糟糕的，这个“疑非仲景法”，又改成了“疑非仲景方”，而

且，窜成正文，这样就成了这个方子本身不是张仲景的。把本来很正常的条文，改得就是乱七八糟，面目全非了。而且给后人造成很多误导。

伤寒八九日、风湿相搏、身体疼烦、不能自转侧、不呕、不渴、脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之、若其人大便鞭、脐下心下鞭（湖南科技 1988 版无“脐下心下鞭”，据叶橘泉 1947 年版加入）。小便不利者①、去桂加白术汤主之、（174）

注：“小便不利者”《宋本》作“小便自利者”。

桂枝附子汤①

注：《宋本》作“桂枝附子汤方”。

桂枝四两去皮 附子三枚炮去皮破 生姜三两切 大枣十二枚
擘 甘草二两炙

右五味、以水六升、煮取二升、去滓、分温三服、

去桂加白术汤①

注：《宋本》作“去桂加白术汤方”。

附子三枚炮去皮破 白术四两 生姜三两切 甘草二两炙 大枣十二枚擘

右五味、以水六升、煮取二升、去滓、分温三服、

初一服、其人身如痹、半日许复服之、三服都尽、其人如冒状、勿怪、此以附子术、并走皮内、逐水气、未得除、故使之耳、□①法当加桂四两、（注）此本一方二法·以大便硬·小便不利

②去桂也·以大便不硬·小便不利·当加桂·附子三枚·恐多也·虚弱家及产妇·宜减服之·

注：

1. 《宋本》无此缺字符号。
2. “小便不利”《宋本》作“小便自利”。

胡希恕：风湿也为在表之证，此病开始也类似伤寒无汗，到八九日的时候，风湿相搏的证候才明显发作，所谓风湿，是病人平时多湿，感冒风湿，两者相合就得风湿证，即风湿关节炎，此不象太阳伤寒那样疼，此疼的相当的重，故说身体疼烦，疼且烦，以至于不能自转侧，一动就疼。一般急性风湿关节炎是这样的。不呕，说明里面无停饮，不渴，说明里无热即是无少阳及阳明证，这里说明伤寒八九日没有传入少阳病，也没传里。脉浮虚而涩，虽浮，但按之无力，谓之虚，应手有力谓之实，涩，是与滑相对的，脉内血行不流利为涩，如果上下流动滑利为滑，涩主血少，又虚，血又少，故虽是表证，但陷于阴虚证（此阴虚证是为虚证与阴证），所以不只用桂枝汤，而用桂枝附子汤，就是前面讲的桂枝去芍药汤加附子。附子这个药已讲过，起亢奋作用，凡机能沉衰即可用此药恢复机能，其次附子是温热药，去寒湿，《本经》说：治结痹，治风湿拘挛，不得屈伸。所以治风湿痛，不用附子的机会少，当然阳性证不用它，阴性证必用。此方桂枝附子都加重。桂枝可通利关节，表证身疼痛都有桂枝的作用。关节疼呢，当然以桂枝汤为主，由于阴虚去寒性的芍药，加附子治关节疼。若其人大便硬，小便自利者。如果此人因小便不利丧失津液，脉浮虚，血虚津液也虚，大便应硬，这个为实证。此书小便自利，就小便频数，由于小便频数而造成大便硬，这不能发汗，不能用桂枝汤，所以用上方去桂加白术汤主之。津液虚为什么加白术利尿呢？白术现在用苍术，古人不分，术与茯苓这类药，既可治小便不利，也可治小便利，频数，小便自利也治，尤其老年人，如果膀胱失收，小便频数，可用附子配苓术这类药，如真武汤等有效，金匱肾气丸等，由于机能沉衰，膀胱括约肌松弛，致尿频。因小便多而致大便硬，这时不能发汗。在金匱有唯小便数，大便泻皆不可发汗。以发汗最丧失人的津液。小便数津

液亡失致大便硬，非治小便不可，用附子术使小便恢复正常，使小便不自利，大便也不硬了。同时附子术二味配合可治湿解痹的，桂枝附子汤是桂枝、附子、生姜、大枣、甘草五味药。本来有桂枝去芍药加附子汤方，现又另立方名，是分量不一样，桂枝四两，附子三枚，由于治痹痛，桂枝附子需重用。附子在此就除湿解痹解疼，桂枝去桂加白术汤，即上方把桂枝去了，其它都一样，另加白术四两。看看方后，上五味，以水六升，煮取二升去滓，分温三服，初一服其人身如痹半日许复服之，三服都尽，一日把三付药都吃了，古人一回煮三付药，其人如冒状，即感觉头沉，勿怪，即不要怕，是以附子术并走皮内助水气未得出，故使然。这由于附子术二药并走皮内，助水气，而水气没出，攻冲头脑，感觉头冒。水气一除就没有此情形了，法当加桂四两，依法应加桂，因风湿在表，此本一方二法，此去桂是根据病情不同了，这是一个方子，二个方法，以大便硬小便自利，去桂也。桂枝不但发汗也治小便不利，治气上冲。利小便的药都有桂枝，没桂枝的很少，如五苓散、苓桂术甘汤、苓桂姜甘汤很多，桂枝治气上冲，凡气上冲，都诱导小便向上，不下行。所以用桂枝使小便往下走。所以桂枝必去，又因桂枝解表发汗，所以必去。此时主要的一方面去湿解痹，一方面治小便自利而恢复大便硬。白术不但利小便，还能治小便不利，如用酸枣仁也治失眠，也治多眠。有人说生枣仁治多眠，熟枣仁治失眠，其实不是那事，我用生枣仁也治失眠，也治多眠，只是病人因为虚而造成的用之皆可。术与苓也是一样的，看你如何配伍，如配桂枝则利尿，配附子也利尿，但机能的沉衰，也影响到小便自利，故亦治小便利，如肾气丸在金匱里面就有，所以女人有肾下垂使输尿管扭转或折叠，尿入膀胱受障碍，可致小便不利，用八味肾气丸可以治就是附子的作用，能恢复肌张力，使下垂的脏器恢复正常的位置上来，所以输尿管正常，小便必利。所以中医辨证必须辨寒热虚实，真正虚证的小便不利，用它行，否则有害无益。所以不能说拿哪个方治

小便不利，哪个治自利等，要辨虚实，与脉与证皆有关。在此脉浮虚而涩，他是一个阴证的虚证。我在用此方的时候有变化，桂枝汤治这种病是非常好的，我就把这二个方混合用，就是用整个桂枝汤就是。不是这样的虚衰，桂枝汤整个用是可以的，然后加附术。这个治一般的关节炎相当好使，我经常这样用，就是桂枝汤原方加附子苍术，这里说其人如冒状，这个附子这个药有个反应，要大量用就有眩冒的，不但冒而且晕，甚至象喝醉酒样，还想吐，这都是过量了，我们用此药开始不要大量用，逐渐加量没事的，开始用三四钱、四五钱都没问题的。附子中毒得用到几两，大概七两，可药死人。少用没关系的。桂枝也可以加量，疼的厉害，也可给四两。这个在风湿、类风湿都有用的机会，以至于骨刺类的病，即骨质增生，脊椎，颈椎等，但如果是偏侧痛，尤其骨质增生的有压迫神经，不是整个疼，哪一方着重，哪一方就疼的厉害，这时要加大黄，后来要学的大黄附子细辛汤治疗一侧痛。古人通过临床所下的结论，每每都有效。大概骨质增生这类病，都是一侧痛的多，加大黄不要太多，一般六克即可，最多加十克。这个很好使。骨刺我也治多了。就用桂枝汤加术附加大黄。当然痹也不只是这个方子，但以这为多。有一次开会用桂枝汤加术附做一个定方治关节痛，很有效。

李冠杰：这条文在《康平本》是顶格的条文。

条文中的“小便不利者”，在《宋本》改作是“小便自利者”，虽然一字之差，意思差得挺远。咱们在具体地解读中会分析。

“伤寒八九日”。前边的这类论述很多，指的是患表证已经多日了。

“风湿相搏”。这个风湿相搏，要是当作中医的一个概念规范的解释，中医典籍里的解释是：风邪与湿邪侵犯人体后，互相结合为患。我们今天解读，我一直有自己的看法，人体患病主要还是人体内部的问题，去对着外界的因素、外因，这是西医循证医学的思维方式。解

读的话，应该指的体表停饮这类的情况。至于体表停饮造成什么病，那是下边论述的内容了。

“身体疼烦，不能自转侧”。这儿论述的就是体表停饮而造成的，以身体疼痛为典型症状反应的一个情况。体表停饮情况很多，比如大青龙汤证，也是典型的体表停饮的方证，但是很少出现身体疼痛的这种程度，它跟这个病理上不一样。“身体疼烦”指的是身体疼痛剧烈，患者常常全身感觉疼痛得剧烈，下一条有关节疼痛这方面的。“疼烦”的是致使患者心烦不宁，疼痛得比较厉害。“不能自转侧”也形容疼痛得剧烈，以至于都不能自己转身。实际上可以自己转身，但转身就疼，就是说疼痛会造成身体活动的不灵便。

像这类的症状，在实际临床中患者的症状不一定会反应这么强烈。在经方里有好多这类的论述，它论述的症状比今天看到的要强烈一些。我想这里面有其他的一些原因：一是那个年代人的劳动强度比较大，相对身体素质比现在要好一些；另外，就是医疗条件比较差，常常把病由轻拖延到比较重的程度才治疗，所以医生看到的症状反应常常会比较严重一些。我小的时候，经常听说病人发烧发的浑身通热，量一量体温 40 多度，烧傻了，就是烧得智力出现了问题，影响大脑了。现在看，有失智这方面的因素，恐怕有的也属于过度治疗，有的人就因为输链霉素造成器官方面、五官方面的一些后遗症。但是，现在的病人再发那么高的高烧的，就比较少了。

“不呕，不渴”就是指的既没有半表半里证，又没有阳明里热证。

“脉浮虚而涩者”。按这条的论述，这个脉象应该是该方证中一个比较典型的脉象。但是今天解读应该客观的对待。为什么呢？现在脉诊上有把脉诊绝对化的倾向。在临床统计资料统计到的 25 个医案中，没有一例出现这种脉象的。当然，我们不能因此而推翻两千多年以前古人对这个病症的总结，因为我们不知道当时的情况。但是，从另一个角度来理解，至少我们可以得出这样的结论：这个方证中所列

举的这种脉象不一定没有，但绝对不会是仅限这一种脉。另外，可以换一换角度来理解，咱们可以认为这个作者有意的用这个脉象，来暗含着方证本身就是体表停饮而陷入阴证的一种病理，用这个脉象来强调一下。

这个方证的病理是：属于阴性证（从大量地用附子肯定是一个阴性证），是一个阴性的表虚证，又合并了里虚寒证与停饮证。

对“风湿”这个问题，我们有必要深入地讨论一下，等于是通过这个方证做一个延伸。因为下一条条文里还有类似的论述，这是其一；另外，因风湿造成的肢体疼痛是经方论述得比较多的内容，现实生活中患此类疾病的患者也比较多，咱们有必要重点解读一下：

条文里的“风湿相搏”，是古人对体表停饮造成很多疾病在病理上的一个认识。我们到了今天，都认为风湿与外界的湿气和风气作用人体有比较密切的关系，一直到现在还是用这种方式来界定这种疾病。现代疾病里不也是还有风湿嘛！在临床中，凡是患这类疾病的病人，随着气温、湿度的变化，他的病症也会有所变化。天气干燥的时候会轻一些，空气湿度比较大的时候会重一些；或者处的环境比较潮湿的时候，也会重一些。这样呢，不管是现代医学也好，传统医学也好，都把目光集中到了外界的致病因素上。所以形成了典籍上解释的“风湿相搏”，就认为是风邪和湿邪作用于人体。

但是实际上，条文说的反倒是比较客观，条文里是这么论述的（这只是这种病的一种途径了）：“伤寒八九日”（前面伤寒十多日的都有啊）之所以造成这种情况，是因为没有得到合理地治疗，由表证发展而来，这是疾病的一个真正的原因。你试想一下就行，同样身处在湿度比较高的环境中的人，并非每个人都得这类的疾病。这都是不争的事实，没有必要去讨论。没有任何资料能够支持得风湿的病人所曾经处过的、诱发他得病的环境，风和湿的问题比任何一个没有得过这种病的人都重，没有这样的，不存在这个规律。外界因素它只是诱导

疾病的一个诱因，真正的原因还是人体的内环境不能适应。在潮湿的环境里他病严重了，不是潮湿直接侵入到里边去了，而是人体适应潮湿环境的能力比较差，也就说他身体里所含的废水成分本身就比常人多；那么，当常人处在潮湿环境下，通过人体内部的调节能够去适应，不至于有不适的感觉；如果本身就处在这种病态，人体没有能力去做那么大幅度的调整，他适应不了，感觉不适感更严重了，病情加重了。归根到底还是自身形成的这种情况，不是外界因素造成的这种病。

既然外界只是一个诱因，那么人体里出现什么情况了？根据学到的经方知识，我们可以仔细地想一想：人体患表证的时候，为什么人体会发热？为什么脉会浮？这都是人体把大量的水分都输送到体表，这是人体的一个本能。一旦出现体表状态失常的时候，就会形成这么一种机制，输送过来的大量水分，它要通过水分的输布，改善体表的内环境，最终要达到汗出表解的目的。它想自己实现这个目的。但是，常常因为人体本身的机能不足，这种机制不能在没有外界干预的情况下自己达到。如果能自己达到那病就好了，每一次感冒都可以喝点热水、热汤啊，自己都能汗出就好了。当它达不到的时候，反而因为这个机制产生的过程大量地消耗人体的能量，具体到这个方证，就是使人体陷入了一种机能沉衰的状态。在这个过程中，当然不仅仅是因为体液往外输布了，因为它病比较重，人体比较弱，你想风湿病患者，哪一个人是很壮的人？就说人体本身就比较弱，又处于这种机制的情况下，人体没有那个能力了，内部出现了沉衰的情况，已经到了比较重的阴证程度了。在这种情况下，原本送到体表的这部分体液，没有实现出汗的目的，它没有出去。要按正常基本健康人的标准，这些体液还可以随着人体正常的代谢过程，它可以慢慢再回来通过小便排出去。可是，因为是机能沉衰它还回不来了，就停在体表，没有能力把这些水分通过正常的代谢过程排出去，那么这些水在这个地方对人体

而言就成了无用之水。水总是要等新水不断地去代替旧水，新水过来的才有营养，旧水停在这儿不进行代谢了，就没有营养了，就成了废水了。这时候人体就处在一种病态了，风湿实际上是这么来的，至少这是一个途径，大致应该不会出太多。

至于说外边的湿、外边的风，大家想想，谁小时候没洗过澡啊？还有比那个湿度更大的吗？所以说那都是外界的诱因，不是真正的原因，不是外界的水分侵入到人体里边去对人体怎么着了。首先是人体本身的内环境已经是处在一种病态。旧水、废水滞留在体表，它影响了新水的输布这种代谢过程；其他的地方，比如内脏里的代谢基本上还是正常的，只是体表正常的代谢被抑制了，这个时候体表就会出现缺乏营养的情况，新水过不来嘛，就等于说缺少这部分营养，就会出现疼痛。

现代医学所谓的坐骨神经痛、腰间盘突出等等的好多疼痛病，都归结于神经，为什么啊？因为找不到疼痛的根源，不知道为什么痛。咱们看中医里边治疗疼痛的药：白术、薏苡仁、附子，除了附子主要是来振兴机能的之外，其它的都是加快体液循环的、加快体液代谢的药物。当然要细分析的话，如果用泽泻它就没有这方面的功能，那是另一回事。它是通过恢复体表的体液正常代谢，来实现体表内环境恢复到正常状态。它在病理上也就是这么一种状态，这也就是被后世称作“湿痹”这类疾病的主要发病机制。只有我们认识到这个层面上，在这个基础上再回头来看看治疗这些疾病的相关方剂，看看它所用的药，才能明确地感觉到它为什么可以治这个病。

关于这类的问题，大家可以看看胡老专门有一个“痹症”的论述，论述得非常好。从这当中可以去体悟、去分析疾病背后的实质，特别是胡老把所有痹症的条文都集中到一块儿，做了比较和延伸。大家可以进一步地看看，对在临床中治疗痹症肯定会有帮助的。

下边是方解：

桂枝附子汤有五味药组成：桂枝、附子、生姜、大枣、甘草。这个方剂可以看作是桂枝去芍药汤，桂枝加了一两，另外加了三枚附子。三枚附子按通常的计算应该相当于三两，一枚至少在 15 克左右，应该相当于汉代的三两。这个方证的特点是里既虚还寒，已经陷于阴证了，而且还有停饮。这个时候，芍药不太合适，所以把它去掉了。再换一个角度，我们可以把这个方剂看作是桂枝加附子汤去芍药，这样好像更确切一些。但是这个方剂中附子的用量，由原来的一枚增加到三枚，这在经方里用附子的量也是比较大的方剂。这可以折射出方证阴性的里虚寒证比较重，如果不重用不着这么大量的附子。正因为这样，在实际临床中这个方证常常会出现心悸、气短这类反映人体机能沉衰的症状，气短和心悸都是因为机能沉衰和停饮造成的，主要还是机能沉衰的问题。这个心悸绝不是心脏亢奋的象征，不是因为热造成的心悸，而是循环系统因为沉衰，不足以支撑人体循环的需要所表现出来的一种症状。

下面再看看“去桂加白术汤证”，也就是桂枝附子汤去桂加白术汤。条文里论述：“若其人大便硬，小便不利者，去桂加白术汤主之”，在《宋本》里“小便不利”被改成了“小便自利”，虽然就差一个字，但意思差别很大。像这样的改动只有王叔和一个人可以做。在《康平本》和《宋本》之间，有可能对这个书进行改动的，现在知道的史料，只有王叔和一个人。从这个地方的改动，我们能看出当时王叔和在整理的时候，是非常非常仔细认真的，这一个字说不定他推敲了多少遍。我们现在站在王叔和的角度上，他肯定会感觉：按照一般的规律，小便不利大多数情况下，会出现大便偏溏啊，而这论述的却是大便硬，水份哪去了？恐怕他是出于这方面的考虑，感觉这种论述与他理解的常理相悖、不相符合。所以对此作了一个更改，改了这一个字。凡是对经方比较熟悉的人都知道，经方里的小便不利，也包括小便频数的症状，这都属于体液代谢不正常所发生的症状反应。具体到这条里，

我们应该进一步地认识，这地方论述的是比较特殊的一种病态：一方面体液代谢不良，前边已经说得比较深入了，体液代谢不良出现小便不利，这是正常情况。另一方面，大量的体液都停留在体表了，机能沉衰又无法将这些体液还回到消化道里边。而且因为内脏的机能不足，消化道内反倒是缺少津液，胃肠吸收津液的能力也呈现低下的状态。这个时候大量的水份在体表，而胃肠所吸收的水份不足以保持正常的状态，这时候会出现大便硬。这是比较特殊的一种情况，而不是按常理能把它推通的。

实际上，这也正是方剂里去掉桂枝的一个原因。桂枝有什么作用？大家想想桂枝汤就知道了，芍药本身肯定不是用来解表的，桂枝是用来解表的。其他的药，生姜有一点解表的功能，剩下的甘草、大枣都是安中养液，强化胃肠的功能，让胃肠吸收功能增强，其中就包括了水份吸收得好。吸收好了以后能增加能量，支持桂枝、生姜把这些能量调动到体表去，用来恢复体表的正常状态。如果肠道里本身就缺乏水分，机能又沉衰的情况下，再加上桂枝行使这个功能，会与人体的病势成了顺势，那么就会加重大便硬的情况。虽然未必对体表的状况不好，但是对里反倒是不好。加重了胃肠水分的缺乏，对胃肠来说等于夺了里边的津液，这个时候里边津液进一步虚的话，就有可能出现其它的变证。它本来大便就到了硬的程度了，如果再硬会不会结滞呢？但是到了宋本中，它给改成了“小便自利”，看起来好像很有道理，但这是机械地解读经方理论的一个典型的例子。近代这类的倾向依然存在，就是说对经方理论解读偏于机械，不能灵活地、深入地去正确理解。

这个方证的病理是：阴性表虚证合并里虚寒证与停饮证。

做个小结：患伤寒八九天的时间，患者出现了风湿相搏，并表现为身体痛烦，不能自转侧，既没有里热证，也没有半表半里证，脉浮虚而涩的，为桂枝附子汤主治之证；如果患者同时又表现为大便硬，

小便不利的，则为去桂加白术汤主治之证。

这个方剂为什么去桂枝，给大家已经说得很透彻了，咱们就不再深入地去讨论了。在这个“去桂加白术汤”的方后注解中，说了因为方剂中附子的量比较大，可能会出现瞑眩反应，也对它的机理做了一定的解释，我们可以参考。但是有一个旁注内容，它认为这个三枚的附子恐怕多，“恐多也”，这个可以说是画蛇添足了，没有必要。经方里边，除了方证不能相应，或者服法与经方的要求不符以外，只要是方证能相应，服法也是对的，根本就不存在药物配比不合理的问题。所以说这个注解没有道理。

风湿相搏、骨节疼烦、掣痛不得屈伸、近之则痛剧、汗出短气、小便不利、恶风不欲去衣、或身微肿者、甘草附子汤主之、（175）

甘草二两 附子二枚炮去皮破 白术二两 桂枝四两去皮

右四味、以水六升、煮取三升、去滓、温服一升、日三服、（注）初服得微汗则解·能食汗出止·复烦者①·将服五合·恐一升多者·宜服六七合为妙·

注：“能食汗出止·复烦者”《宋本》作“能食，汗止复烦者”。

胡希恕：这个比上面那个痛还厉害，骨节疼烦，掣痛，是一种牵引痛，疼的厉害，且不能屈伸，近之则痛剧。汗出短气，自汗出，短气里边有停饮，里有停饮压迫胃就短气，这是金匱说的，心下有停水，厉害了心悸，微者短气，短气都是胃有水，小便不利，水不下行。此不但外面有湿，里面也有停饮，所以非用桂枝不可，气冲的厉害，往上，故水也不往下走。恶风，不欲去衣，前者讲了虽外有热，不欲去衣，此寒在骨也。此正是阴虚证，阴证则恶寒的厉害，这些都是属少

阴病类的。有表证，也有桂枝甘草，由于如此恶寒恶风，故加附子。甘草附子汤主之，就是桂枝甘草加附术，桂枝汤加附术，桂枝甘草加附术，桂枝去芍药加附术，这些都在治关节痛经常用的。疼的厉害，气冲的明显，用这个方子，桂枝甘草汤前面讲过了，也解表，右四味，以水六升煮取三升，去滓，温服一升，日三服，初服得微汗则解，因有桂枝是要发汗的，能食，汗止，复烦者，将服五合，能食，也不出汗了，还烦，再吃五合，恐一升多者，宜服六七合为始，开始的时候用一升太重，可服六七合，逐渐增加。这个方子也比较常用。如果临床风湿，且气冲的厉害，小便不利，用此方比较好。以上三段都是讲的风湿类的病，古人叫风湿相搏，又有外感，同时又有湿痹，古人叫它风湿相搏证。

李冠杰：这也是一个顶格的条文。

“风湿相搏”，放在这个条文里边它有两层意思：一个是论述甘草附子汤的病理，另一个示意这个条文与上边 174 条有一定的关系，那不有一个“风湿相搏”吗？这示意跟那个有一定的关系，包括病因方面，都是相通的。

“骨节疼烦”，明显指的是人体的关节疼痛剧烈，也造成人心烦不宁。但这里集中在关节上，跟 174 条那个“身体痛烦”有明显的差异。一个是表现为全身，一个是表现为关节。

“掣痛不得屈伸，近之则痛剧”，就不止是关节疼痛这么一个问题。而且这种疼痛呈现的是牵扯性疼痛，不活动还好点，越活动越严重，疼痛得越剧烈。所以，这儿的“不得屈伸”，就是屈伸就疼得厉害嘛。“近之则痛”，则是指的有肿痛这一类的情况，你要触摸或者按压这个关节的话，疼痛得就更明显。这实际上就是指的像关节炎这类的，关节有发炎有肿的这种情况。

“汗出”，一方面是表虚证，另一方面也有阴证的因素了。

“短气”，有气上冲和停饮这两方面的因素，再加上机能沉衰，

造成人呢有短气的这种情况。

“小便不利”，这是典型的体液代谢不好的症状反应了。而且在这个方证当中，气上冲严重，这个地方可以理解成加重“小便不利”这个症状的一个因素。有气上冲的这种趋势，它带着体液有往上走，而往下走的趋势就被抑制了。所以说也会影响到“小便不利”。

“恶风不欲去衣”，形容“恶风”的程度比较严重，不仅仅是表虚证的恶风了，在更大的程度上是由于人体机能陷于沉衰，出现的阴证所造成的这种怕冷。

“或身微肿者”，就是指这个方证，或可能出现水肿的情况。这是体液代谢不良而偏于体表停饮，出现的一个明显的症状反应。

这个条文里论述的“甘草附子汤证”，虽然在病理上与“桂枝附子汤证”基本差不多，但是，由于这个方剂的适应证：气上冲比较严重，同时对水分吸收不良这个问题，没有桂枝附子汤那么明显，所以这个症状反应也不尽相同。这个方证是以关节部位的病变为主，而上边那个方剂则是以全身的症状为主。这个地方也能看出，为什么在桂枝附子汤的基础上，可能出现“去桂加白术汤证”？就是因为体表停饮要重，不仅仅是关节，而且是全身性的。

甘草附子汤证的病理：阴性的表虚证合并里虚寒证，还有停饮证、气逆证。

下面做个小结：因风湿相搏，导致患者发生骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧，汗出气短，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿的，为甘草附子汤主治之证。

这个方剂也就这么四味药：甘草、附子、白术和桂枝。这个方子可以看作是桂枝甘草汤加白术附子。理论上这个适应证应该是在桂枝甘草汤证的基础上伴有停饮，而且陷于阴证的，它的适应证应该以桂枝甘草汤证为基础。但是实际上，这个方证在条文的论述也好，还是实际临床当中的表现也好，它确实以关节疼痛和关节部位的肿痛为主

证的。桂枝甘草汤证，或者说桂枝甘草汤证的那个主证，在这个方证里边出现频律很低。

我们体悟经方的方证，不能机械地、主观地去解读。把经方的方剂，凡是能拆成几个方剂，能合在一块儿，就是这几个方证的简单相加。在经方上有这方面的因素存在，但是这个规律常常不能体现在所有的方剂当中。如黄连汤和半夏泻心汤，三个泻心汤在方证上就比较接近。像我治的这个病人，虽然说他有肠鸣，我也没给用半夏泻心汤，因为那个药跟半夏泻心汤非常接近，轻微的肠鸣肯定能治了，吃了就好了；就算是那样的话，黄连汤证那一类的腹痛，绝不是半夏泻汤能治得了的，或者说疗效会很差。尽管药差别不大，就差那一味，桂枝和黄芩的问题，但是疗效会变化很大。像这个方剂也是这样，我们不能机械地认为：就是有桂枝甘草汤证的所有症状，然后出现了停饮，又有机能沉衰，不是。

所以说在这一方面应该客观地、深入地去对经方的这些用药特点去体悟，只有你在这方面有所感悟、有所掌握、有所进步，以后在用经方当中，你才能用得活。

症状：关节疼痛、恶风寒、汗出、四肢屈伸不利、尿少、关节肿（下肢膝踝多见）、短气、头晕、恶心、流涕。

舌质：淡、紫。

舌苔：白腻、薄白。

脉象：沉、细、弱、迟、弦、滑、濡、浮、紧。

现代疾病：痹症（中医诊断）、风湿性关节炎、神经痛、肩周炎、坐骨神经痛。

伤寒脉浮滑、白虎汤主之、①（176）

注：

1. 此条文《宋本》如下：

伤寒脉浮滑，此以表有热，里有寒，白虎汤主之。

知母六两 石膏一斤碎 甘草二两炙 粳米六合

右四味、以水一斗、煮米熟、汤成去滓、温服一升、日三服、①

注：《宋本》此处有林亿等人所加按语如下：

臣亿等谨按：前篇云，热结在里，表里俱热者，白虎汤主之。又云其表不解，不可与白虎汤。此云脉浮滑，表有热，里有寒者，必表里字差矣。又阳明一证云，脉浮迟，表热里寒，四逆汤主之。又少阴一证云，里寒外热，通脉四逆汤主之，以此表里自差明矣。《千金翼》云白通汤，非也。

胡希恕：这段很存问题，伤寒脉浮滑，浮主表热，滑主里热，如果太阳伤寒的症状，而脉浮滑，此表里俱热，可用白虎汤。但此证候决不是表有热，里有寒。里有寒怎么用白虎汤呢？注家说法不一，有说是表有寒，里有热，也不对，表寒也不能用石膏，且与脉也不对。寒多指邪说的，表有邪里有邪，表有邪，里有热，总而言之，这段成问题的。从方后的说明就知道了，林亿等谨按前篇去热结在里，表里俱热者，白虎汤主之，前几段我们讲了，白虎加人参汤证，有这些话，说白虎汤证，热结在里，表里俱热，用白虎汤。为解释这一段，没说白虎加人参，其实那是白虎加人参。又云其表不解，不可与白虎汤，此因脉浮滑，表有热，里有寒者，必表里自差矣，这是林亿他们的按语。他说这一定是表寒里热，是表里二字弄反了。应该表有寒，里有热。又阳明一证云，在阳明篇有这么一条：伤寒脉浮迟，表热里寒，四逆汤主之。如果是表有热里有寒，决不能用石膏，用白虎，应用四逆汤。由此证明，这绝不是表有热里有寒。……他说的这个千金翼说，白通汤主之，认为林亿说的不对，此条与阳明病那节，交互有错误，说白通汤那个脉应该浮迟，浮为在里，迟为里寒，说是表热里寒是对的。那个用四逆汤不如用白通汤。可能是白通汤，白通那个药，是干姜、附子、葱白，葱白配合干姜附子，前者解表后二者温里，既治表邪又治里寒，四逆汤只温里不解表。此段脉浮滑，滑定是白虎汤脉，

但证没明白。后面有“千金无是语，以为玉函经之误”，林忆举这个说是千金翼，是这样说的，不对，在玉函经是这样的，玉函经是这样说的，他说这段应是白通汤，看看 64 条的注解，玉函经此条云：伤寒脉浮滑，而表热里寒者，白通汤主之，旧云白通汤，翼云白虎者恐非。翼是王叔和的注。玉函经这条说脉浮滑，表热里寒者应该用白通汤主之，但是这也是错的，白通汤脉不应该浮滑，应该是迟了，白通汤脉浮滑呢，又不应有表热里寒，证不对，所以这个是前后串，四逆汤那条就是后面讲阳明篇，应该是白通汤，那人是脉浮迟，表热里寒者的白通汤主之，这条脉浮滑，应为表里俱热，把这一段互相穿插错误了，把这二段弄串了，弄得白虎汤与白通汤，二个都不对。白虎汤那个表热里寒是不对的，白通汤是四逆汤那个不对的，甚至在白通汤，我们在少阴病将讲，少阴病下利与白通汤那节也错了。

这一段要这样体会，表里俱热，所以脉浮而滑，浮为表热，滑是里热，白虎汤不渴，这段也没说渴，渴就加人参。

李冠杰：“伤寒脉浮滑，白虎汤主之”，这个条文非常得简，但是这个条文在《康平本》里是顶格条文。

但到了《宋本》里边，把这个条文给加了一些内容，《宋本》里边这个条文是下边这样：“伤寒脉浮滑，此以表有热，里有寒，白虎汤主之”。那么这儿呢差别就大了。而且这个条文，历史上很多都认为是问题的。

“伤寒”，在这儿可以理解为：本方证可由太阳表证发展而来。

“脉浮滑”，是这个条文里唯一的述证，唯一的一个症状。所以这个条文非常得简略，简略之极可以这么说。是用“白虎汤证”当中常见的一种脉象，来示意这个疾病的病理。

其实把重头放在哪了呢？把重头放在方剂上。我们说得直观一点，当你学经方学到这个地方的时候，你去看看方剂，它应该有哪些症状？你自己就应该明了。实际上，白虎加人参汤已经有过比较详细

的论述了。就是说这一类比较简略的论述方法，在经方其他的地方还有。都有一个共同的特点，有治疗方剂做参考，并且在其他的条文里边有论述，所以说这儿就用简略的方法。

另外从一个很务实的角度来看这个问题，从临床统计资料看，白虎汤证这个症状反应统计到了二十六种症状。而且这二十六种症状，出现的频律不能说没有差别，差别没有那么大。

另外呢，这个白虎汤证是典型的里热证，从方药里边一眼就能看出来。方剂也是典型的清肃里热的药，没有一味是温药。那么再加上第 219 条和第 350 条，有关这个方剂的论述，还有其他的佐证。白虎加人参汤就是在这个方剂的基础上加了一味人参。关于白虎加人参汤的方证的论述，就有五条之多吧。所以说，这个经方的原文给我们提供的这些资料，对于理解这个方剂来说，可以说是足够了。

可是，就是在这种情况下，还是有人给妄加了一些内容。使一个本来正常的条文变得不可理解。这个条文要是康宋两个本一比较的话，《宋本》多出了“此以表有热里有寒”八个字。

不管是谁加的，但是在这个条文里边加的这些内容显然是错的，这个方剂不存在里寒的问题。

到了宋代的时候，宋朝的校正医书局的那些人，在校正这个书的时候就发现这个问题了，可以说是最早发现这个问题。发现这个问题以后，就加了一个按语。这按语呢，大家看一看就行了。

下边是白虎汤证的病理：非常单纯，就是里热证。

当然，如果跟白虎加人参汤证比的话，基本不存在津液虚的问题；如果跟其他的有停饮的那种热证比，比如跟猪苓汤证比的话，它还应该算是偏于津液虚的，因为里热把津液蒸出体外一些。但是我们现在呢，在病理上认识它主要就是里热证。

下边作个小结：

表证因失治或治疗不当，致使患者表现为脉浮滑等里热证候反应

的，为白虎汤主治之证。

这个方剂就是四味药组成。前边我们学白虎加人参汤的时候做过不止一次地介绍了，不再重复了。

这儿呢，我觉得有必要跟大家说一说白虎汤证在临床统计资料当中，可以见到一些什么症状？在这儿跟大家简单地一说：

一共统计到的医案是 333 个。出现频率最高的症状是发热 195 例、烦躁 142 例、口渴 137 例、多汗 103 例、小便短赤 96 例、面红赤 89 例、口唇干裂 57 例、头疼 56 例、便秘 54 例、谵语 50 例、咽干喜饮 47 例、神昏 45 例、唇红 36 例、目赤 33 例、斑疹 32 例、呕吐 30 例、喘促气粗 30 例、心悸 28 例、手足逆冷 28 例、形寒肢冷 27 例、食欲不振 26 例、腹泻 25 例、口臭 25 例、咳嗽 24 例、胸痛 20 例、腹痛 20 例。

这印证了古人为什么把这个方剂的方证说得那么简。这反倒一下偏到另一个方向去了，你自己去体悟。或许这个方剂放在太阳病篇的最后，也有这一方面的考虑。就说放得很靠前了不好论述。初学的人也不易理解这个方证，会这么复杂。

舌质：红、绛、镜面、裂纹、舌硬、舌有瘀点瘀斑、淡红、焦黑。

舌苔：黄、厚腻、干燥、薄、白、少、黑、无苔、灰。

脉象：数、洪、沉、滑、弦、实。

现代疾病：中医诊断：温病（春温、风温、暑温、湿温、冬温）、疟疾、阳明实热、伤寒、消渴、霍乱、胃热证、热厥。

西医诊断：流行性感冒、肺炎、呼吸系统、内分泌系统、妇科及皮肤科疾病。

伤寒解而后、脉结代、心动悸、炙甘草汤主之、①（177）

注：《宋本》此条文如下：

伤寒脉结代，心动悸，炙甘草汤主之。

甘草四两炙 生姜三两切 人参二两 生地黄一斤 桂枝
三两① 阿胶二两 麦门冬半升去心 麻仁半升 大枣三十枚擘

注：《宋本》此处有“去皮”二字。

右九味、以清酒七升、水八升、先煮八味、取三升、去
滓、内胶烺消尽、温服一升、日三服、（注）一名复脉汤

胡希恕：这个脉结代不一定要用炙甘草汤，但是心动悸，血不足以养心，则心动悸真正的由于虚，现在由于阴虚了，可以用炙甘草汤。有些结代脉，如前面的抵当汤，脉沉结，沉脉中见结，沉脉有时停一下。所以实证里头有很多是瘀血证，反倒用下剂，可是实证没有心动悸，如果心动悸相当厉害，动悸是惊恐的意思，玉函经是“惊悸”，这时炙甘草汤是有作用的。

此方是桂枝汤去芍药，里面有桂枝生姜大枣甘草，另加些滋阴药阿胶、麦冬、麻仁、地黄。同时加人参健胃。所以生血生津液，胃要是坏了是不行的。而且方名也给我们个启示，生地用1斤，麦冬半升都是大量，不说生地麦冬汤而说炙甘草汤，炙草不过四两，为什么？甘能养脾，古人认为是甘药都是健胃的，这里滋阴药皆为甘药，尤其麦冬，麦冬汤解释有健胃作用，这方主药是健其胃气为本的，尤其阴分太虚了，当然也给滋阴药，桂枝外调营卫，此方主要内滋阴津液，然后健其胃气，这是一种治血虚，脉结代的正法，不健胃是不行的。所以遇到血虚津液虚，大滋阴把胃弄坏了，是恢复不了的。后又称复脉汤是错的。真正脉要是绝，那只能用通脉四逆汤，此方复不了脉。这都是千金搞的。此方是治结代，出现间歇，复间歇可以，不是没有了。真正到了心脏衰了，此方寒性药用不得。后面讲的通脉四逆汤就是，那只能救胃，所谓救胃扶阳，胃气保住一分，人生命可挽回一分，如果胃气全完了，人就好不了，必四肢厥冷，血液达不到四末，基础在胃，胃为水谷之海。胃一点消化作用也没有，到那时吃这药不行，

一点寒性药也不能用。

李冠杰：这是一个顶格的条文。但在《宋本》里也给改了，改成了“伤寒，脉结代，心动悸，炙甘草汤主之”。

“伤寒解而后”，在条文中应该理解为表证失治，病情进一步地发展，脱离了表证的病理阶段，而发生炙甘草汤证；或者说是表证治疗不当，人体再无力从表证阶段与疾病抗争了，表证也消失了，而后发生了炙甘草汤证。这两种理解都可以。但是不能理解成表证经过正确的治疗以后，发生了这个方证，这是不可能的事。表证经过正确的治疗的话，一般在经方这些药里边，假设这人是小柴胡汤证，吃了以后小柴胡汤证消失了；或者过不了多长时间出现表证了，这个属于正常的，因为随着人体的恢复，体表存在的问题，只要有能力它会自己去处理。但是如果小柴胡汤证治疗得很合理，属于正治，小柴胡汤证消失了，又出现理中汤证了，这种可能性几乎没有。这就跟一个单位的管理一样，最上层领导如果特别团结，特别稳固，规章制度特别健全，那么出问题就会出在中层领导，要是中层领导非常过硬了，出问题会出在具体职工、具体车间身上；要再把这一层搞得稳固了，就可能出现在设备上，而不会是反过来。

“脉结代”实际上是结脉与代脉的总称。结脉是指的脉来缓而时有一止，而且止无定数；代脉为脉来一止，止有定数，良久方来这样的脉象。在临床中这两种脉常常是合到一块儿，泛指脉律不齐而且有歇止的这类脉象，就是咱们常说的间歇了。在炙甘草汤证中出现这样的脉象，它的病理就是由于血虚、血瘀、津虚血少，造成循环系统失养。

“心动悸”，在《玉函经》里是“心惊悸”。但是从实际临床统计资料中看，这个方证很少有“惊恐”之类精神方面的病，《玉函经》里的“惊悸”恐怕不太合适。心动悸在《中医辞海》里是这么解释的：病症名，指的是患者不仅自觉心悸，或可察见心前搏动，其动应衣。

也就是说人躺着，心跳得衣服都跟着动，就是说心律不齐比较严重。这个症状实际上应该包括两个方面：一个是医者的观察，病人就是一种或程度重、或程度轻的心律不齐；在患者自己的角度上感觉，就是因为心悸而造成的胸部不适感。

前段时间有一个男性的老年病人，我让他吃的炙甘草汤。后来他跟我说这个药管用，他说知道自己的心跳跳几下就会停一下。我问他平时自己摸脉吗？他说不摸，他说躺在床上时候，靠枕头的那半边能感觉到血管在跳，就是心率能感觉到。但是吃了药以后，这种情况渐渐地就消失了。

这个条文论述得比较简略。但是从这个方药和临床资料看，这个方证属于比较重的虚性病。所以临床中还会出现一些气短、胸中烦闷、失眠（睡觉不好，因为有虚热）的症状。

方证的病理：血虚、血瘀合并里虚热证兼津液虚证。

做个小结：表证因失治或误治，致人虚而表证消失，患者表现为脉结代、心动悸的，为炙甘草汤主治之证。

这个方剂值得看一看，方剂由九味药组成，但如果算上清酒应该是十味药：甘草、生姜、人参、生地、桂枝、阿胶、麦门冬、麻仁、大枣。很多人解释这个方剂，都会说包括了一个桂枝去芍药汤的所有药物，就是以桂枝去芍药汤为基础的。但是，我们无论从原文的论述上，还是从临床统计资料看，这个方证不仅没有任何表证的症状反应，而且也没有桂枝去芍药汤证的典型症状。个别的患者可能会表现为胸部不适，但这个“胸部不适”跟那个“胸满”不是一回事，这个胸部不适是因为心悸、心律失常造成的。所以说，我们对这个方义的理解如果把握得比较准，也可以加深对经方方药特点，甚至可以延伸到经方组方规律方面的一些理解。

这个方剂中先不看主药，甘草、大枣用量比较大，再加上还有生姜，所以说“安中补虚”的作用就比较强。在这个基础上又加了人参，

可以进一步增强胃肠对水分的吸收。这就从源头上解决了津液虚的问题，给治疗津液虚提供了一个前提条件。

麦冬是一味寒性的药，有补益作用，同时又是一味润燥增液的药物，麦冬用到了半升，如果算成干品大概相当于四两左右的样子。

生地黄和阿胶都是寒性的而且有补益性的血分药。生地有补血、活血、止血、生津解热的作用，由于血虚、津液少所造成的烦热、出血、瘀血一类的症状都能够治疗，但是必须得是虚热性质的，因为它是补益的、寒性的药物，这是它的前提条件。可是这个药用到了一斤，就是十六两，是现在的 250 克左右，用量非常大。阿胶有补血、止血、活血这类的作用。这两味药的药性从主要方面比较接近，从寒热属性上、对血液的作用上都比较接近，都是补益的。

麦冬、生地、阿胶这三味药用量比较大，合在一起寒热属性比较明显，在一定程度上决定了这个方剂所治疗的是虚热、血虚、血瘀、津液虚，这是该方剂的属性。

麻仁是一个性平的药，寒热倾向不够明显，它有润燥滑肠、通凝、活血的作用。在这个方剂中可以治疗因津液虚损而造成的便秘。实际在临床中，凡是符合这一类病理状态的，比如现在有些小姑娘的脉，又弱又数，人瘦瘦的，脸色黄黄的，有血虚又有津液虚，平时食欲也不太好，体质也比较弱，如果再加上便秘，用这个药就好使。如果有别的方证，用了也不好使。我以前说过，治一个小姑娘用炙甘草汤后，大便通了两天又不通了，最后仔细的问了问，才发现是大柴胡汤证，服了大柴胡汤，很长时间一直比较正常。

这个方剂中还有桂枝去芍药汤的所有药物，但它在这里的作用就不能理解成桂枝去芍药汤了。应该怎么理解呢？刚才说的那些药物，总体上形成了一个去热、补虚、补血、活血、增加津液力量很强的药性，这些药性作用于人体后，这些方面肯定会得到增强。桂枝去芍药汤就可以把增加的能量加以引导，用来改善人体胸部和循环系统的状

态。大家想是不是这么回事？它为什么可以治心悸呢？

方中的清酒原本应该用没有经过蒸馏、自然澄清的那种清液，但是今天没有人酿这类酒了。现在北方都用黄酒，南方都用米酒。酒的作用可以加强方剂的活血化瘀作用，现在好多人也都不用了，可能作用会受一点影响，但是不会有质的变化。

这儿我突然想到一个问题。最后的几条王叔和几乎都做了改动，而且都改得没有道理。包括炙甘草汤证，把“解后”两个字去掉也是没道理，如果有了“解后”两个字，对方证的理解会更准确些。在其它的地方也有所改动，但明显得感觉都比这个地方要慎重得多，不会出现这么低级的错误。特别象白虎汤证的“里有寒”，明显是个错误。为什么会出现这种情况？我在这儿做一个大胆的设想：他老人家当时很可能是喝酒了，在第二次改动的时候，是处于一种酒醉的状态。这都是题外话了。

炙甘草汤证出现的症状及舌脉情况：

症状：心悸、气短、胸中烦闷、夜寐不安、神疲乏力、面色无华、便秘、食欲不振。

舌质：红（红、嫩红、尖红）、红绛、紫、紫带瘀点、淡（嫩淡、胖浊）。

舌苔：白、微黄而形薄、少苔、无苔。

脉象：结、代、细、微。

能治疗的现代疾病：中医诊断：心阴阳两虚证、气阴两伤证、阴阳两虚证、气血虚衰证、肺病久咳、产后血晕、心悸、脉结代、呃逆、眩晕、黄疸、伤寒、虚劳。西医诊断：风湿性心脏病、冠心病、病毒性心肌炎、室性早搏、先天性心脏病、频发性期前收缩、房颤、心源性休克、病毒性休克、冠状动脉硬化、心绞痛、病窦综合征、室上性心动过速、无脉症、神经衰弱、植物神经功能失调、脑外伤后遗症、慢性肾炎、甲亢、肺结核、产后感染、中心性视网膜炎。

脉按之来缓、时一止复来者、名曰结、又脉来动而中止、更来小数、中有还者、反动、名曰结阴也、脉来动而中止、不能自还、因而复动者、名曰代阴也、得此脉者必难治、（178）

胡希恕：脉按之来缓而时一止复来者，名曰结，这里解释结脉，结阴，代阴，这几种脉。结是脉来之缓，缓不是慢，不是迟。迟而一止谓之结，故而一止谓之促，是错了。脉按之没力量为缓，即是太阳中风之脉，弱，脉绷的不那么紧，脉道弛张，为缓脉，时一止复来，有时一止，马上又来，为结。结脉，结者，绳子有结，虽有疙瘩，但前后有联系，疙瘩过去还是绳子，结脉问题的，正常人也可以有的，不管快慢，数中一止也叫结。又脉来动而中止，脉来不是缓而是摇动，即动脉，跳动而摇摆，为动脉，脉来不平静，而中止，不是时一止而复来，而是终止了，中间没有了，然后更来，但小数，脉细小而快，这个脉是最坏的，是极不整的脉，一摸脉有如跳动的怀表，然后没了，再来非常小，且疾数无度，中有还者反动，也不是整个是终止也有时停一下也来，但来了，还是动，还是摇摇摆摆的，一阵快一阵慢，或一时摇摆，一时不摇摆，这个坏的很，所以说名曰结阴，这个在一般的脉书里面不提的。是最虚了。脉来动而中止，同前面一样没了，不能自还，因而复动，比较长的时间，脉又动，名曰代阴，就这个脉没了，而另外一种脉代替它来了，叫代阴。也是极不好的脉。现在临床上，时一止而来为结，中止良久再来叫代，如果脉来的快慢不均，脉身跳动不已，这是怪脉，此为结阴或代阴之类的脉。结脉比较轻，代脉比较重。

李冠杰：第 178 条是关于脉的论述的，大家自己看一看就行，没有多深的含义。

太阳病小结

胡希恕：那么到这儿呀，我们把太阳篇就讲完了。讲完了，我们回头看一看，咱们作个总结。仲景这个书啊，他在头一章，太阳病篇笔墨费得相当地多，全书共计 112 方，咱们讲过的方大概是 74 个，我数一数，可见在全书一半还多了呢！112 方吗，这就占了 74 方。那么这个书，他对太阳病怎么说的，我们根据这个书来略略地谈一谈。

我们看这个题目，“辨太阳病脉证并治”，从这个题目我们就看出来了，古人啊对这个病，或者是辨，或者是治，都根据脉和证。这个证是症状的“症”，不是辨证的“证”。根据脉的形象，和全身的症状，而来辨证施治。题目的含义，我们看出这些来。

那么太阳病是怎么一个证候，怎么一个脉象呢？他开始就说了，太阳病，脉浮，头项强痛而恶寒。太阳病啊脉是浮的，同时呢有头项强痛而怕冷这一系列的证候，就叫做太阳病，所以有给注解说是太阳病的提纲。提纲这个意思就是，凡是太阳病啊，它提纲挈领嘛，提纲挈领上来说它是脉浮头项强痛而恶寒的，根据这提纲的意义，那么也就是我们辨证的一个证候，可以说太阳病的特征。那么就是说我们在临床上怎么认识太阳病呢？这个病要有脉浮头项强痛而恶寒者，我们

就可以确断它是太阳病。开始这一段说的是太阳病的形象，中医只是这么来看病啊，什么道理，我们讲完了再解释啊，根据这个书上，咱们现在这么说。

那么这个太阳病还有两个类型，就是说大概研究有两个大的类型，一个是太阳病（这个太阳病就概括了上面说的脉浮头项强痛而恶寒了），说这类的太阳病，另外要有脉缓，这个脉缓呐，它就有那个脉浮了，脉浮缓了，发热、汗出、恶风、脉缓者，这是中风的一种证候。他说太阳病有两大类型，一个就是中风。中风我们认识，也离不开脉和证候。他说发热、汗出、恶风、脉缓，那么太阳病那个证候具备，再有这个情形，这就叫做太阳中风。那么另一个呢？就是太阳伤寒。太阳伤寒与中风不一样，中风一开始就发热，这个伤寒啊它也必发热，但是不是开始就一定发热，所以他说或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名为伤寒，他说这个类型啊叫做太阳伤寒。两个大类型，他说太阳病有这么两个类型，这我们在临床上都是经常遇到的。

他说还有一种病，你不要拿它当作太阳病，发热而渴、不恶寒者为温病，所以太阳病啊必须要恶寒。这一种温病，温病就是表里俱热了，这个你千万不要当太阳病来治疗，所以底下接着说温病发汗后就变成风温了。里虽热，它不实啊，下之也不行，用火攻更不行，把人治死拉倒。他这个主要不是讲治温病，那个他将其搁到阳明病里头了。那么在这儿他讲的是太阳病，所以他是特别提出来两个类型，所以温病现在叫做“病”，同太阳病是同等对待的。它不像中风、伤寒，中风、伤寒不叫做“病”，叫太阳中风、太阳伤寒。这个温病呢，形似太阳病，而不是太阳病，所以叫温病，与太阳病是不同对待的。这个很重要啊，所以这个温病看着象表证，其实不是纯表证。

那么另外，这个太阳病什么时候发生呢？就是病之初作，一般热性病的初作大概都是发生太阳病，所以开始有“伤寒一日，太阳受之”。

那么病之初作，它是这个表证，就是表证。但表证不光是太阳病啊，还有一种少阴病。所以他有那么一节，“病有发热恶寒者，发于阳也”，太阳病就是发热恶寒啊；“无热恶寒者，发于阴也”，那么咱们在临床上也是，遇到这么一个无热而恶寒，这种表证，它是少阴证。这是讲的太阳病和少阴病，解释一下，就撂在这儿了。那个少阴病，我们之后讲少阴病时再说了。可在这儿我们可以看出来，表证里头有阴、阳两种啊，阳病者就是太阳病，阴性病者就是少阴病。那么他是明明白白在这儿就说明一个问题啊，就是太阳病就是表阳证，又是表证，又是阳证，是不是，这不是很清楚了吗。

然后我们再来往下看，这个太阳病的发作呀，是病的起始，这个病呀它要传变的。所以他也说，这个太阳病，尤其我们前后看，在四五天、五六天的时候，常常由表传半表半里而发生少阳病，咱们讲的柴胡剂全是。你看看这个书都是四五日、五六日（传少阳），这是一般。也有特殊的，十多天它才传少阳也有，两三天就传少阳也有。但是以最常见在四五天、五六天。

它不但传半表半里，也直接传里，那都在六七天、七八天的时候。这也是一般，它由表直接传里而发生阳明病。这他说明什么问题呢？说这个太阳病啊，由表往里传，表里相传了，它或者传半表半里，或者传里。这与《内经》的六经就不一样了。他的书也引用那些话，（但）很少。但是我们这个太阳病讲完了，总结看到意思还是这样的。我们看到有少阳病传阳明，没有看到阳明病传少阳。他用那小柴胡汤不行，服柴胡汤渴者，是属阳明也，它转属阳明了，它由少阳病可以转属阳明。在阳明，它没有转属少阳，在这个太阳篇里也没有。那么它是表里相传，太阳病由表可以传里，也可以传半表半里。这是咱们讲这个太阳病，这都是根据这个书啊。

那么他还说什么呢？说这个病啊有并病。什么叫做并病呢？就是太阳病传里，或者传半表半里，太阳病没完，那个里或半表半里病发

生了。这两个病，先得的病并于后面这个病同时发病了，这叫做并病。太阳病未罢，这个书（上）有的是，那么它发病，这叫做并病。这也是太阳病里提出来的。太阳少阳并病，太阳阳明并病。其他也有并病啊，少阳阳明也并病，它由少阳传阳明。那么三阴病有没有呢？也有啊，咱们没讲三阴，先不谈三阴。

在这里头还有一种合病，也在太阳篇里讲了。说的太阳阳明合病，太阳少阳合病，太阳少阳阳明合病，三阳合病就是。这个合病什么意思呢？就是这个病的发作又有太阳病症，又有阳明病症，就叫做太阳阳明合病，这个同时发作的，一开始得病就这样的。这个不像病传那个并病，那个是先发生这个，后发生那个，但是这个也没完，那个还发作呢，叫做并病。合病呢，同时，一开始来病就这样的，这在临床上也很多，这叫做合病，咱们这个书上说的。我们讲这个都照形象讲的，形象变化，太阳病的形象和太阳病的变化，就是上边说这些。另外呢，他讲治疗。治疗也是一个咱们讲辨证施治了，当然得先辨太阳病。我们在临床上遇到外国朋友前一段（时间）恶寒，根据这种的脉和证，我们就辨他是太阳病，他的初的意思就这个。太阳病了，你还得辨什么？还得辨它是中风型啊，或者是伤寒型，也根据脉证。那么这里面啊他常提到寒热虚实，那么可见在这个太阳病的基础上，咱们太阳中风，开始就用桂枝汤嘛。用桂枝汤这类的发汗法。要是无汗这类的伤寒型，他就要用麻黄汤的发汗法。但是桂枝汤所说的中风型啊，无论是中风型，或者是伤寒型，这个证候还是千差万变的，那不是老那样子，怎么办呢？还得因证而施，他这个就是具体的事实具体分析，所以桂枝汤里头有很多加减方，麻黄汤里头也有很多的加减方子。还是根据这个寒热虚实往下辨。辨到什么（情况）为止呢？就是这个方药恰好相适应了为止。比方说吧，太阳中风这类的病，是用桂枝汤。那么桂枝汤证，项背特别地强，项背强几几地，要加葛根。那么如果这太阳病脉沉迟，里边虚，而且有寒的样子，要加芍药、生姜、人参

新加汤，这是很多了。可见仲景这个辨证啊，是由大的范围逐渐缩小，最后是方的适应证，简单言之就是方证。这个很重要，所以方证是辨证的最后一个尖端。那么中风型，或者伤寒型，它恰好是中风那么一个形象，就像书上说这个，发热、汗出、恶风、脉缓，那你用桂枝汤是对的。但是它要再有出入，那桂枝汤就应付不了了，你还得往下辨，到什么（情况）呢？就是这个方药恰好适应为止。所以我们根据他这个辨证施治，这套东西，我们知道了，他先辨六经，这个先辨太阳病了。然后再缩小，就是同中找异了，辨一个中风型或者伤寒型，因为太阳病啊就这么两个类型，大概言之。然后再根据其他的一切情况再细辨，到方证为止的。所以辨证啊，这个方证，在他这个书上来看，是一个最后的尖端啊。

我们讲这个太阳篇，讲很多东西啊，讲些定法。什么叫做定法呢？我们方才不是说了并病、合病，大概是并病最常见了，最多了。这个表里都有病啊，并病吗，外面也没好，里面发生了。那么这种表里同时有病，如果里实，应该攻；要么得心下痞，应该用大黄黄连泻心汤。但是他还恶寒，表证未已，得先解表而后攻里啊。就是表里并病，而里实者需攻，你得先解外，而后攻里。如果里虚寒，需用温补，你要先救里而后救表。这是定法，这个在临床上很重要啊。所以我们在临床上遇到一个人下利清谷，他也有发烧、头痛等等的，你得先治下利清谷，他那个脉当然也是，也是大概都是一个沉微、沉细这一类的脉。这个你不能先解表，虽然身疼痛，不能先解表。这是定法。那么再有，虽然有表证，但是他有柴胡证，有少阳病，少阳病不可发汗。甚至于他也有里证，也有少阳病，那么少阳病也不可下。这个汗下俱当（力戒），就只能用柴胡，要不柴胡这味药，比较应用范围多啊。这也是定法。这个太阳篇里也有。那么还有一种在临床上常见的，这个人内有停水，小便不利，内有停水，这类的病啊你非利小便不可，你要不利小便，就来解表不行，那个危害相当大，变证相当多。不利小便，

表决不解。有的时候（解）表与利小便同时用，你看这个桂枝去芍药加茯苓白术，就是这个方子，你象小青龙汤也是的，心下有水气，表不解。这个在临床上也很重要，这也算一种定法。

另外呢他又提出来了，有些太阳病依法当发汗，但是发汗有些禁忌也要知道的，他提出来七种。这个大家就得记，那没有旁的办法。我们在临床上遇到这个可发汗，据病可发汗，

但是有些特殊情况不可发汗，主要的是丧失血液，丧失津液，那么这个津液、血液特别虚，所以亡阳者不可发汗，亡阳就是亡津液了。表现出这么样的，你象咽干口渴啊，无论是疮家啊汗家啊亡血家啊，都不可发汗。对于这个，我们的脑子里得有，要不然就出大毛病了。这个都是他这个书怎么讲的，咱们怎么回头来谈的。

那么我们还要研究一些，研究什么呢？他说的六经究竟是个什么东西。仲景这个书啊（讲的）就是辨证施治了，他是拿一个伤寒作个例子，而来写辨证施治的方法方式的。那么我们研究古人书啊，我认为（得）注重这么两个问题，一个就是这个方法方式，中医通过实践来的，大家没有谁反对，因为咱们这个中医发展太早啊，那个时候没有一种基础理论给我们，象西医有那些基础科学的（支持），在这个基础上演绎出来的一种医疗制度。中医不是的，那阵儿没有（这些），科学还没发展到这个地步。只是从经验，要不咱们怎么辨脉辨证呢，怎么不辨病啊？没法辨病啊。限于那个时候（的科学水平）啊，没有显微镜，也没有 x 光，什么也看着不着，肉眼看着不着的东西太多了，没法辨病，而且这个局部病变更看着不着，那除非剖开看，所以就是势必促使（中医）辨脉辨证。那么他通过实践呢，得出一些结论，你象我们讲这些都是得出的结论啊，太阳病，脉浮、头项强痛而恶寒，脉浮、头项强痛而恶寒就是太阳病，你遇到这个，当太阳病看没有错的，这是通过结论，通过临床作的一个总结，这是客观存在的，什么时候也是这样，古时候太阳病脉浮头项强痛而恶寒，现在太阳病也不例外，

也是脉浮头项强痛而恶寒，在以后也不会变，它是客观存在的，这是自然科学，自然科学里的自然规律。古人通过实践，把这种规律掌握了。可是他对这个规律怎么样来认识是存在问题的，那时候限于科学水平吗，他没法说肝有病，这是真正是肝炎呐，什么病菌造成的，什么病毒造成的，他不会的，他说不出来这东西。那么他也要说，你可知道，咱们说这个六经啊，他搁上这个经络的名称就是这个道理。你象咱们说这个中风伤寒，在古人只要认为这个，人伤于寒则为热病啊，那个伤寒，古人也是这么看的，错误，这是个错误啊，所以现在咱们不能这样说了。那么西医说是这个伤寒杆菌啊，人家能给你找出实际的东西看，你不信还行吗。所以咱们说那个冬伤于寒，这个就成问题的。那么我们这个六经也是的。所以认识这个问题啊，古人的认识有些是我们应该废弃的，应该扬弃的。现在咱们还都是古人怎么说，怎么来的。这个是有问题的，这个也不是一时能改变的，不过我们根据他这个书，你看太阳病明明是表阳证，那么表阳证，表证，阳证，同时他也分析寒热虚实，这里头八纲具备啊。表、里，他也常提啊，表里阴阳寒热虚实都有了吗。

可见仲景的书就是八纲辨证，那么怎么搞出个六经来呢？所以今天在这儿，我们略略把这个问题谈谈。不过这个东西太多，我今天简单地说一说。那么开始得对八纲有一个认识，大家都说八纲，可是这个八纲并不那么简单，怎么一方面结合临床，一方面结合这个书，我们略略谈一谈。所说这个八纲啊，本来它是九个，你看他这个书也是，表、里、半表半里，所以他搁个三阴三阳篇吗，三阳三阴篇。他这个阳性病啊，表、里、半表半里都有，阴性病呢也都有。就我们方才讲的太阳病，它在表，表证有两种，一个阴一个阳。发热恶寒者，它是阳，无热恶寒者就是阴，这个书说得也很清楚。那么可见它就是一个八纲，所以我们现在先要把这个八纲说清楚，那么它实质呢，表、里，应该有个半表半里，这个古人说表里啊，就把这个半表半里概括进去

了，就是指其两端，那个当间啊自然就在内了。

那么什么叫做表呢？这个表它是人体一个部位，就是体表这个表，就是人这个躯壳，就是由皮肤、肌肉、筋骨组成的躯壳，这是在人体上是最在外了，体表的表。那么病邪反映到这个部位，就叫做表证，所以身体疼痛这是表证。你象我们方才说的这个风湿病，都是这个身体疼啊，所以它也属表，它脉也浮。

那么这个里呢？它就指的胃肠这个消化道，它是在人身上极里之里了，你看上至食道，胃，小肠，大肠，肛门出去，这个就叫做里。这个里，我们把它纵剖开，那是最里头了。所以古人说这个里啊，全是，书上也是阳明篇，太阳篇也提过，“胃不和”，胃就是胃里面不和，胃中不和啊。就这个就是里。如果这个病邪反映到胃肠里面的这种证候，那就叫做里证。

这个半表半里呢？它就是表之内，里之外，那么现在就是说胸腹腔间了，这么一大块地方。那么这个空间呢，里头可是有很多脏腑啊。你象咱们一切的脏器吧，除了脑子，都在这个胸腹腔间。所以病邪反映到这个部位就叫半表半里。比方说，胸胁苦满啊，尤其咱们讲这个柴胡证，那胸胁苦满就是在腹腔间，他觉得胸胁这个地方发满，发胀满。所以它叫做半表半里。

那么这个表、里、半表半里说明什么问题呢？就是疾病反映的病位，病的位置。这个位置，不像西医说的那个病的位置，那个说你病变在哪个位置，中医他讲证，咱们讲的这个证候，这个证候反映的病位，这个不是疾病所在的病位。中医也叫表证也叫病在表，这是一种术语吧。但是他说这个邪在表，并不是那个病在表得的，所以这个外科，咱们研究外科就知道了，这个疮生在外边，它也发生里证，它大便干燥啊，也要用泻药，里证，其实病是在外边。那么我们说这个病位就是，病在里，它也有表证。所以从这个疾病的反映上来看的。那么这个病位啊，它是固定的，也就是说疾病万变，它反映到人体上，

不出这三个病位，不在表，就在里，或者半表半里。有的时候表里并病，既有表又有里，合病也是的，同时发作两个、三个，但是不出这个范围，不出这个表、里、半表半里这三个范围，要出范围中医没门了，它不出这个范围。这也是古人经久地临床作的结论，这也很不容易。

另外呢，咱们说他这个三阳篇、三阴篇，把这个阴阳也得把它搞清楚。这个阴阳啊，是就病的病情上说的，也就是病之性，阴就是阴性，阳就是阳性。什么叫阴性？病发作起来，这在人的机能上的一种反应。这个人体机能啊，它是要起改变的，代谢机能首先要改变的，这是西医也这么看的。这个改变呢，它只有两个途径，不是太过了，就是不及了，就这么两种。在临床上也是的，咱们脉也是的，它不是快了，就是慢了，不是大了，就是小了。你象前面我们说那个滑、涩呀，其实它就这样。你象我们量血压表也这样，有病人咱们给量血压，他的血压高了，你的血压低啊，血压不高不低，你血压这方面管保没病。那么快慢也是啊，现在这西医也瞧脉呀，瞧脉他看钟点，也就看快慢。所以这疾病一发生，影响机能改变，这种改变啊，不是太过就是不及，如果太过，你身上证候反映都太过，不及呢？你身上的证候反映也多不及。这太过是哪一方面呢？比如说亢奋，发烧，兴奋，这个病呢发扬，这一类的情形，古人叫阳性病。反过来呢，它现抑制的现象，冷啊，衰沉啊，脉也微呀也细呀，这一系列的都发现，这叫做阴性病。这阴阳就是这么两个，一个是发扬的，一个是抑制的，一个是亢奋的，一个是消沉的。所以少阴病一讲，脉微细，但欲寐，人就消沉，就困顿，而且脉也比较微细。那么太阳病就不是了。它就这么两种。所以这个疾病万变啊，不外乎这么两大类，它不是阴，就是阳，不是亢进，就是不及，反正就这么两种。也不亢进也不不及，这就是常人，没病。这就病情上说就这么两大类。

那么另外它有寒热虚实，这个寒和热本来就属于阴阳啊，那么寒

就寒性，热就热性。让中医说说这个热，不一定得是温度高啊，红头涨脸，你象这个口苦口干，这都是一种热象，脉数也是表示有热。这个热也是太过，也属于阳性。这个寒与它相反，寒就是寒性，这个人颜面苍白也是寒性。总而言之现这种寒性的就为寒，现热性的就为热。在阴阳里头提出这么两个（概念），因为这个在治疗上是很有关系的。这两个寒热虽然属于阴阳，但是它是具一个特性。咱们这个阴阳是极概括的，凡是太过的都属阳，凡是不及的都属阴。这个寒热呢？它是特性，局限于或寒或热这么两种。所以我们说，阴阳包括了寒热了，它是概括它，那个寒热概括不了阴阳，所以疾病啊，没有不阴不阳的，可有不寒不热的，我们在临床上也是，这个人没有寒热吗，你还说他有什么寒热，但是阴阳能分。

这个虚实也是的，这个虚，古人说的是人的精气虚，就是人虚。实呢就是，古人说病气实，就是邪实。你象我们讲的太阳病，无汗、脉浮紧、身疼痛，它这个在表证上说是实证，一点汗也不出。你看这个中风证呢，它就是虚证，它是自汗出，脉也弱了。它这个实证，咱们讲有那么一段啊，说太阳病，十余日，表证还不解，吃了麻黄汤之后发烦目瞑，继之鼻衄，衄乃解，所以然者，阳气重故也。他说阳气重，重就是老不出汗，他外边这个体液充实太甚了，就是实，就是表实，什么实呢？病实，指着病说的。人虚，虚劳那个虚，那是人的体力支持不了，也就是这个病还没去呢，人就支持不了的那个样子，就叫做虚。人体力能支持，但这个病气相当实。你象这个阳明病，胃家实，大便不通，人说胡话，谵语，这是里实证。这个虚实也属于阴阳啊，总而言之虚还是不及，实还是太过，也属于阴阳，它也是个特性，专就虚实这么一种阴阳来说，分的虚实。这个虚实共寒热都附属在阴阳里头，可是寒热虚实这两类东西要是错综互见呐，那么这个虚实常常的，我写那么一篇东西呀，我说寒热有常，虚实无常，那什么意思呢？寒热有常啊，（无论）在什么情况下，是寒就属阴，是热就属阳，

它永远不变。这个虚实无常什么意思？唉，它与寒热交叉互见的时候，它就是随着寒热为阴为阳，它自己呀就反其阴阳了。这个呢我们说几个例子就有了，比如说吧，从这个阳性病，热，实，又热又实，这是阳性证。可是热与虚在一起，虚本来是属阴呐，与热在一起，咱们说虚热证是阳证了。这个虚随着这个热走了，所以虚实它无常，这个虚与热同时并见了，这个虚就变成阳，本来它是属阴呐，它就为阳了，虚热证是阳性证。因为这个寒当然是阴证，寒证，再虚，虚寒，这当然是阴证。这个实，与热，我们方才说了，当然是个阳证。这个实与寒呢，这个实就变成阴证了，寒实证，咱们头前讲的寒实结胸啊，那个用不得一点凉药，那个也得用差不多的温下法，咱们这个太阳篇也有寒实结胸。所以这个，虚实这两个东西，咱们说虚证属阴，实证应该属阳，但是实证与寒结合到一起，它反为一种阴证，这个虚与热结合到一起而反为阳证，所以它是无常的。那么这样子在阴阳里头啊，有这么两个大类型，阴阳两类，所以六经啊，它只是有阳实证，有阳实热证，也有一个阳虚热证，也有阳热证，也有不寒不热不虚不实的阳证，它五种。所以这个阴证里头呢，有阴寒证，有阴虚证，有阴虚寒证，有阴寒实证，也有不寒不虚，就是一般的阴证。所以都有五个。所以我们辨了阴阳了，还要细辨底下这套东西，辨这个寒热虚实。那么这六个呀，阴阳寒热虚实，我们统言之就是有阴阳，寒热虚实就统为阴阳。那么这六个都是病情，可是这个疾病的反映，它这个病情必须反映到病位上啊，它得有着落呀，你看这个人是寒是热，哪一块寒哪一块热呀？它必须反映到病位上，反映到表，说表热，反映到里，说里热，反映到半表半里，半表半里热了，所以这病情啊必须反映到病位上。那么这个病位，你象我们人，每个人都有表，都有里，都有半表半里。你说这是表证吗，它没有病情反映，没有证的反映，哪啊，所以这个病位也必然得有病情反应，它才有反映，那么这就出来这个六经了，没有病位也就没有病情，没有病情也就没有病位，所以

我们见到一个证，它同时就有两种，既有病位，也有病情。咱们讲这个八纲是抽象地讲的，那个病没有单独那么有的，你象咱们讲这个六经就是，它都得有个病位，同时有阴阳两类的病情，因为这个寒热虚实统说在这个阴阳里头了，所以表有阴阳，里有阴阳，半表半里也有阴阳。那么表、里、半表半里，就这么三个病位嘛，这个病就有阴阳两大类嘛，那么 3×2 不等于 6 嘛，就是 6 个类型。这 6 个类型啊，就是天然它就存在的，它是最基本的类型了，所以咱们这个六经啊，我们根据这么个分析啊，就是表、里、半表半里各有阴阳两种病型，这个它是始终存在的，那么我们说的六经啊就是这个东西。可是古人呢，或者那个时候这么说觉得浅，必须找出个理由来，所以他说一个经络受邪，咱们这个书啊有这个口气呀，太阳病就是太阳经发病。这个是大问题的，这个咱们也不必驳斥他，和大家好好研究研究啊，这个一研究就知道，这个经，这个经络，古人说它，大血管就是经，小血管就是络。那么这个经络发病，是不是这个？有可能，这个值得研究。所以中医这个辨证啊，至于六经这个证候的发现，不外乎八纲这么个问题，就是病位上反映病情，就是病、症之形成，它必须有病位，同时有病情。这个病情概括言之阴阳两类，这个病位呢固定在表、里、半表半里，这个与人身有关系。我们人身呢，认为这个疾病万变，在中医上这个八纲概括一切，这个六经也是的，一切疾病不出这个范围，所以咱们辨证啊，才能什么病都能辨的，要假设出这个范围啊，那么这个书咱们学它也是没用了，它不出这个范围。它为什么不出这个范围？它与人的结构是相通的，疾病尽管发病的原因不一样，病的种类不一样，发病的形式也不一样，但是它有一个共同的反应，一般的反应。这一般的反应怎么来的？这个柴胡剂说的，正邪纷争啊，这是中医学一个很好的认识啊，在内经上这个也常提。这个人体啊不甘于疾病来向自己发展，它要对付疾病的。它要对付疾病，这种斗争的形式它就反映出来了，我们讲的太阳病我给分析了，这个太阳病你

根据证候一分析就知道了，脉浮、头项强痛而怕冷。这个脉为什么浮啊？这是一个常识了，现在说，就是血管充血，这个感冒大家都得过，一得这血管就崩起来了，是不是就充血了。怎么叫充血啊？就是血管也扩张了，那里头充斥液体太多，所以头项强痛。为什么单头项强痛啊？他脚丫子怎么不强痛啊？它就是上半身特别充血，这个你看看生理学就知道了，所以要出汗以前啊，它先血管扩张，然后那里头的体液啊大量地输送到外头来，然后就出汗，它把这热也放出去了，那么我们这个太阳病啊，就是这个充血达到一个相当程度，不但充血，同时里头也携带有热，那么这个热呀，比平时特别高了，在体表（温度）骤然间提高，与外边这个温度差距加大，那么感觉外边就冷，刺激身上这个恶风恶寒呐由之而起。那么头项这个地方不但充血得厉害，而且有压迫性的疼痛，所以强痛啊。那么这个情形正是要出汗而不得出汗这么一种反应，为什么要出汗啊？就是要体表排出汗，解除疾病。所以中医这个认识很好，全是正邪纷争。那么在人体有了疾病呢，要是最好的法子从汗腺排除。这个从作战上讲是外围作战啊，影响不到里头。但是病沉重了，由体表解不了了，咱们讲这个少阳病就是，它要退却了，就是另找防线了，所以这个血弱气尽腠理开啊，咱们讲这个柴胡剂很好，邪气因入，这个邪气呀不在体表斗争了，它往里头来了。可是呢，二道防线也就是在这个时候成立了，结于胁下，正邪纷争，结于胁下，在半表半里这个部位，这个胁下这个部位在胸腹腔间最重要了，在这块斗，所以往来寒热，咱们那段讲的很好，在内经上也是的。表证就是邪正交争于体表，内经说的很好，邪正交争于骨肉，那么得到汗出，那就是正胜邪却了。我们这个太阳病呢，就在这么一个阶段上，想要汗出，达不到汗出，表解不了。所以古人通过实践，在这个太阳病啊以发汗为原则，正是恰好适应这个病理机制，所以它叫做原因疗法嘛。那么这个是我个人的看法啊，这是根据这个八纲分析的六经，这是自然而然地形成这么六个基本类型。我们要这么去看

呢，那么张仲景这个书啊就是八纲辨证，这个太阳病，这是古人的看法，古人说太阳经受病。所以张仲景这个书啊，据这个皇甫谧，晋人，作这个《甲乙经》说的，他说论广汤液为数十卷，他这个书是有蓝本了，不是他自己创作的，创作不了这么……。在他以前呐有本《汤液经》，在《汉书》上也的确有，他们有说伊尹作的了，当然那是无稽之谈了，中医这个不是一个人作成的，它是一个从临床实践中逐渐搞出来的，当然有个很长的时间了，不过在《汤液经》那个时候，它这个概要都具备了，你象这个六经名病啊，据我的想法在这个《汤液经》上，那么张仲景呢在作这个书的时候，他是根据《汤液经》。皇甫谧这个人啊，他不只是对医学有修养，他是个历史学家，所以张仲景跟同郡的张伯祖学医，那都是皇甫谧说的。皇甫谧这个人可有考据，所以咱们这个书上这个序言啊要不得的，他那个新本就没有了，这个序言是假的，你们很容易就看到了，皇甫谧是晋人，跟那个王叔和差不多，这个书是王叔和撰述的，假设有这个序言，这个序言明说是撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》这套东西，皇甫谧不会不尊重本人的序，说他是从这个《汤液经》上来的，他说他这个论广汤液为数十卷，可见这个皇甫谧那个时候没有这个序，这个序可能是南北朝那个时候搞的。现在的这个书就没本序了，我的旧本都有，所以这个序言啊对我们影响最大，历代注家呀都根据这个《素问》，就把这个书整个的，说张仲景这个书啊在内经基础上发展起来的，我认为这个是毫无关系。他这个六经与这个，你们回头看看内经这个六经，它就不一样，它说是太阳、阳明、少阳都在表，可发汗，它在三四天入了脏腑，它说那是阴病，那可以下。那与这个书哪对呀，尤其这个，它也不是先太阳，后阳明，再少阳，然后那个说得很妙了，四日太阴，五日少阴，六日厥阴，厥阴之后又返回来太阳，谁见到这个病了？这不成了一个怪病吗，没有。所以那个六经它讲递传，仲景的这个一开始讲表里相传，这是决不一样的。

今天咱们这个就略略谈到这啊，就我方才说这个八纲、六经关系呀，我这么今天讲，你们听得乱七八糟的，我写那么个东西，（你们）参考着看一看。这也通过这个书，那么我怎么导得那个呢，就是根据这个书，这个书我认为就是八纲辨证，三阳三阴篇就是阴阳两大类，同时在太阳病里头他尽讲表，外不解了，表不解了，这都是他说的，根据这个书。那么少阳病，阳明病都讲的里，那么后来三阴病也是的，阴阳两类他同时讲表、里、半表半里。那么他这个六经不就是阴阳之中有表、里，有半表半里，就这么个东西。就根据他这个书，同时也讲寒热虚实，八纲具备。那么这六个类型呢，他古人辨证为什么不先辨表、半里，那个没法辨，它必须得成型，有表有里才能够有脉浮、头项强痛而恶寒呢。假设说没有这个病位，你只是讲阳，哪有那么个病啊。所以它必须有病性，有病位。既有病性病位就这六个，最基本了。那么从这，他是再细辨。所以他这个书啊据我的观察，他是先有的这六个基本类型，这个类型也来自于八纲，就是八纲，在这个类型上是表里阴阳都具备了，他再辨寒热虚实，这个书也确实是这样的，你们好好看看就知道了，再辨寒热虚实，最后辨到方证。所以我说仲景这个辨证的方法呀，就是辨六个类型，就是六经，再分析八纲，八纲呢就分析寒热虚实就够了，它这个表里阴阳都有了，然后再进一步辨方证，以至于治疗。他这个书，这个就是他这个书的一个体系，你这个掌握了，所以我们以后讲也好讲，它就是这个东西。所以我那天写那个东西，就根据这个书，并没有什么。他这个书这么样子来说明啊，在我以前还没有人这么说过，都是求深呐，这个求深我认为是返浅，你象这个经络也是的，这个东西找不出一个相当的证明，这个经络发病啊，反对这个事不是从我开始，这个徐灵胎就说过，所以仲景决不是，他这个书啊，不是循经发病，说太阳经发病了，阳明经发病了，决不是，可是他没说出个所以然来，咱们今天就讲到这啊。

李冠杰：整个太阳篇，如果按照《宋本》的段落划分，一共有

178 条。全书总共有条文 398 条，太阳篇这一篇就占了总条文数量的将近 50%，将近一半的样子；其中包括的方剂 70 多首，超过了全书 112 首（根据统计方法不一样，有的说是 113 首）的一半以上。而且，太阳篇里所论述的内容，几乎包括了经方医学所有的理论观点和基本概念。我们可以毫不夸张地说：太阳篇就是经方理论的浓缩版。正确深入地理解这一篇，是学好经方理论的关键和基础。

到今天，我们已经逐条逐句地把太阳篇学习完了，我们做一个小结。但是做小结的时候，我想首先我们碰到的问题，需要明确的问题，就是一个方向性的问题。什么算方向性的问题？我们这里拿出一个最具方向性的问题，我们需要澄清的：就是应该从基础的方面，整体来理解经方医学的理论。首先要弄清的一个最基本的问题，就是《伤寒论》或者我们现在学的《康平本》叫《伤寒卒病论》，后来也把它改成了《伤寒杂病论》。这些都不重要，就是说这本书虽然名为《伤寒论》，但是它不是一部专门论述所谓外感病的专著。这本书我们仅仅是通过学习太阳篇，就已经能够充分地看出，这是我们的中医先辈们，通过长期的临床实践，总结出来的一个“通过症状反应，来治疗各种疾病的一个完整的医学体系”。

我们今天小结做完了以后，大家可能这种感受会更深一些。这个全书以伤寒和杂病命名，实际上《康平本》这个名字更确切一些，伤寒和杂病本身就有涵盖所有疾病的意思。我们退一步讲，就是按照《宋本》论述的话，太阳篇这 178 条里边，真正论述太阳病的条文也不是很多，很多的篇幅论述的实际都是所谓的杂病，叫它内伤也好，叫它什么也好，都是论述的伤寒以外的病。这里边是有原因的，我们在小结过程当中，会一层一层地跟大家慢慢说清楚。

那么我们学的这个第一篇，按《康平本》这个名字恐怕是个真实的名字了，后人改动的痕迹比较小，叫“辨太阳病”。实际上论述的也不仅仅是表证，同时也包括了经方医学中所有主要的疾病类型，里

边都有。这本书之所以用了这么一种架构，是有它自己特定含义的。为什么我们要先明确这一点？就是这一本书传到今天，我们知道的已经经历了两千多年的历史。

但是我们今天解读的时候，依然还存在着浅层次的一些误解：曾经有人在网上发帖子说过这样的问题，有的学生自己学习经方，学习过程当中碰到一些问题（这是中医药大学里边的学生），去问他的老师有关《伤寒论》上边的某某问题。老师答复什么？《伤寒论》是论治伤寒的，现在哪有得伤寒的，学那个干吗？这是中医药学院里边，专业讲中医理论的老师，不管你是在讲什么理论，但是说出这样的话来，这就说明对中医里边的这些经典的著作误解非常深，理解得过于肤浅了。

我常在思索这个问题：为什么在学术界会出现这样的情况？其实这个道理很简单，大家记得在那个老的样板戏里边，阿庆嫂说过一句话，叫听话听声，锣鼓听音。什么意思？人说了话以后，折成我们现在生活当中，这个人如果笑脸对着你说，但是他说的是骂你的话，那他的话也不是好话，就算是开玩笑也不是好话；如果他绷着脸，但是他说的是对你非常得有益处，那也是中听的话。所以说不用在乎他用了什么口气，用了什么表情，关键的问题是他说了什么。

这书不也这样吗？你那么在乎它是一个什么名字吗？你不看看它论的是什么呢？咱就说太阳篇里边那四逆汤证难道说也是表证？也能算外感病？虽然说像这类的问题比较低级比较浮浅，但是它确实是在中医界就有这类的倾向，我们不能视而不见。这是第一个我们需要澄清的问题。

第二个问题呢，就是我们应该充分地认识《康平本》的重要意义。咱们这次学习，以《康平本》为底本，我们可以这么说啊，就是校对的时候这是一种专业的说法。就是说以《康平本》为底本，那么同时呢咱们参照了《宋本》，将两个版本的异同点，逐一地进行比对分析，

那么我们这样学习呢，就比较系统。而且像我们这种方式、这种内容的，安排来集体地学习中医当中的经典《伤寒论》这本书，这可能在中医历史上，我们这是首次。也可以说这是一个尝试。

那么通过这种形式的学习，我们从中呢，获得了很多仅学习一个版本而无法了解的许多信息。那么我们在整个学习太阳篇的这个过程中啊，大家可能会有这样的感觉：许多东西以这两个版本凑在一块儿，一比较，会发现很多新的信息在里边，而且是你只看一个版本无法了解的。

同时呢，我们也澄清了很多比较重要的有价值的学术问题。这有一个我们需要一再重复的一个问题，就是《康平本》真实可信，学术价值极高。

因为在学术界啊，这个《康平本》本身它回归的就比较晚，1947年才回到中国大陆。就包括像胡希恕这样的伤寒大家，一生也没有机会能够见到这个版本。从他的讲座里边啊，我们明显得能看出来。这就说这是一方面的因素。那么另一方面呢，这个版本跟《宋本》之间，它那个条文的数量几乎是一一对应的，而且条文的内容呢也比较接近。就是因为这样我们把它跟《宋本》相比较之后，我们发现：它能够把《宋本》当中许多没表达出来的一些东西吧给予澄清了。所以说它这个价值呢非常大。而且我们在学习过程当中，它这个整个条文当中啊，这178条里边有许多条文都能够证明这《康平本》是真实可信的。这就说它要如果说是假的，那它一点价值都没有，但是如果是真的，那它的价值就非常的高了。但是我们通过我们这样地学习啊，我们和大家在一块儿用了半年多的时间，一直在一条一条地比对着学习。我们在当中啊，通过分析、感悟，发现很多非常有价值的新的信息。不仅仅我们从多处可以证明，从这个条文当中的多处《宋本》和《康平本》的异同当中，我们可以分析证明出来，《康平本》真实可信；而且我们还能证明《康平本》早于《宋本》，而且内容呢，也比

《宋本》更为精纯。

我们可以这样说：《康平本》是目前我们所能见到的最早的、最接近于《伤寒论》原书原貌的一个版本。

另外一点呢，就是《康平本》的这个特殊的排版方式，这是这本书的一个最大的亮点，也是这本书最具价值之处。从这个《康平本》不同格式的条文排版内容，我们可以知道，对这个历代所推崇的像这个宋本《伤寒论》，其中的内容实际并不是出自一人之手，并不是一个人写的，作者至少在三个人以上。这就等于什么啊？这就等于说是把三本分别由不同的作者论述的论著的啊，著述的这种书籍，把这三本书籍的内容，虽然说论的是相同的问题，但是它毕竟是作者不同、角度不同。把这样的三本书的内容混在一块儿，让读者当一本书来阅读。《宋本》实际就是存在这么一种情况。

那么这三本书啊，我们现在知道的可以这么澄清一下：

一本就是《汤液经》的内容，根据史料我们知道，那就是《汤液经》的内容，就是顶格条文。

那么另一本书的内容是什么啊？是降一字格条文排版的这个作者对《汤液经》，也就是对顶格条文的解读、解释和补充，这又是另一本书。我们可以把它叫做是《汤液经解读》，可以称作这么一本书，但是古人那时候他没有单行另一本。

还有一本，是降两字格排版的这个条文的作者，对以上两本书的解读、解释和补充。

当然另外还有，你像那个旁注啊、嵌注啊，这些内容，有的，明显是这三个作者之外的人写的，但是有的能确切的知道，你比如说像宋朝的人，宋朝林亿他们加的按语，这个明显能看出来。好多那些旁注就已经很难证明是出自谁之手，这类的呢还等于说是悬而未决的，还有这一部分。咱们考虑这一部分呢，这本书里边内容的作者来源还要多。

这种情况就是《伤寒论》这本书在特殊的历史条件下，所形成的史实，这就是历史事实。而且呢，像这样的一本经典的书，从近两千年以前，传到我们今天，出现这样的局面，出现这样的情况，其实一点都不足为奇。这应该是事物的本来面目。

像这一类的书啊，包括《黄帝内经》，《黄帝内经》大家也都知道，实际上里边好多也是后人加的一些内容，这是历史史实。但是我们今天解读的话，必须把这个因素考虑进去。就像我刚才说的，你应该从心里边就得有这样的一个意识，这是三个作者写的，至少是三个作者写的。或者说的直接一点，这是三本书混在一起的，你要想读好，我们再说的直白一点啊，《伤寒论》在出现《康平本》之前啊，大概就是以《宋本》为标准，这就是一本书。但是大家读这本书，不同的读家关于《伤寒论》的解读之类的专业书籍，恐怕那得上千，那就不是一家两家的问题，各说各的。

你真正最可信的是原文，所以说在读经典这个学术圈子里边有一种说法就是：读经典就得读原文。

那么，咱们再返过头来通过《康平本》来看的话，也有一个读原文的问题。什么是读原文？那个顶格条文就是原文。

所以说，说得直白一点，不同的作者就是不同的作者，确实存在差异。那么要如果说我们在这个基础上，再深入地解读这本书，我们就会发现，这本书的不同作者之间，无论是从理论观点上，还是从写作风格上，确确实实存在着明显地差异：

顶格条文的作者，就说这些顶格条文，我们明显能看出来，这就是创建经方医学的基础与核心理论的精华所在，是这一本书的精髓。

那么降一字格的条文，这个作者对经方理论的理解，比较准确和深入；并且也作出了一些理论上的诠释、发挥和临床经验上的一些补充和丰富。

但是，降两字格排版的这个条文，它的内容明显与经方医学不是

一个理论体系。他除了补充了一些比较有意义的自己临床所得之外，多数的理论观点，对正确理解经方理论都有一定的误导作用。

这三类条文各有长短，咱们得客观地看。我们从古人那儿继承来的就这些东西，我们没有必要非得把哪一类作者作的条文，非得把它从书里边剔除出去不可，没有必要。我们继承下来的就是这样一个史实，认清它，是最重要的。

这三类条文各有长短，就是顶格条文也不是说一点问题没有，降两字格的条文也不是一点精华没有。那么各有长短，同时又存在着质的区别，它确实确实存在着这个区别。实际上这才是事物的本来面目呢。你要如果说不是一个作者作的，咱比如说：在学术上、观点上，不同的作者之间比较和谐的，我们知道的，马克思和恩格斯。那两个人他们分别写的不同的书，实际上互相之间也是有区别的，别说是不同时期的。那两个人是整天在一起，在学术上、在理论观点上那是非常接近的，但是实际上，他们的著作也是有差异的，也不一样。所以说这才是事物的本来面目，我们应该这么去认识。

同时，我们通过《康平本》和《宋本》两个版本的对照，也澄清了许多在理解经方理论当中，历来都有争议的一些问题。你比如说：第 176 条，《康平本》当中就是“伤寒脉浮滑”，那么《宋本》当中那些“此表有热里有寒”这一类的内容在《康平本》里边一眼就能看出，它是后人所加的。当我们知道了这个以后，你在网上浏览一些文章或者一些专著，你注意到这个地方的时候，你去看那些人的论述，真是觉得有点啼笑皆非，就说特别牵强。绕着弯子去证明白虎汤证怎么会有里寒，都有点让人感觉到非常可笑。许多历史当中久有争论的一些问题，通过《康平本》和《宋本》的对照，都涣然冰释了，都化解了。

那么，通过对《康平本》地解读，可以进一步明确经方理论的体系。那么，经方理论的体系精髓在哪儿？就在顶格条文里边。那是重

点、重中之重！甚至如果说，假设说，我们中医界把《康平本》的这个意义，都能够认识到位的话，很可能就会经过一段时期的普及之后，那种历代相传的对经方理论的误读的历史，也许就能结束这种误读史。这是第二个，也算是方向性的问题吧，也是一个比较重要的问题。

第三个问题，就是深刻认识太阳篇的意义。

这个太阳篇，从条文数量上看，我们刚才说了，全书 398 条，那么太阳篇就占了 178 条，将近二分之一。你再仔细地分析，细化一下，其中顶格条文，全书顶格条文，大概是，我统计得不是很准确，大概是 170 条左右，171 条的样子，那么太阳篇里边就占了至少是 109 条，超过了半数。

从论述的内容看，这个太阳篇虽然说它以辨太阳病命名，名为辨太阳病。但是实际上，它论述的是在太阳病的基础上，概要地论述了经方理论的各个方面的主要内容，精要都在这儿；也包括了经方理论中的各种疾病类型和各种疾病性质的典型的方证，就是说各种典型的例子都有。并且全面地论述了疾病的发生、发展、变化、转归，这样普遍存在的这种规律性，也在第一篇里边做了比较详细的论述。它都有一个病因。

但是咱们都知道，经方理论重证不重病因，那么病因在这里边，实际上就是要让你在这儿感悟，因为有病因，大家都感觉到这个经方的这种论述，特别像一个医案：病是怎么发生的？经过什么样的误治？又出现了什么样的变证？实际上这里边它蕴含的，大家想想，假设说是临床医案的记录的话，绝对不会是把临床医案凑成这么一个完整的医学体系，那是有点不太可能的。而且不管多少代的积累，最终成书的时候，总是要有一个执笔者的，那么这个执笔者把这些东西弄起来以后，你去看看那个顶格条文，顶格的条文从头至尾，特别是在语气文风上，那就是一气呵成。真是前后都是比较一致的，不像其他的条文那样，有些可有可无的句子、可有可无的一些内容，基本上不

存在这方面的情况。

这个太阳篇，实际就是以太阳病为基点，延伸并且囊括了经方理论所有的精髓和要点。你看，他论得有点乱七八糟的，说的是辨太阳病，但是这里边论述了好多跟太阳病无关的疾病，看着跟标题并不相符，但是，这恰恰就是这个书的一个非常大的特色。如果是带着这个有色眼镜，你再回头去看看《康平本》，《康平本》里后边的篇章里，有的一大类疾病里边，顶格条文只有两条。他就是示意你：我在太阳篇里边已经给你论述了，这个地方我就给你点明这个病属于哪一类的疾病就得。

那么为什么是那一类病，他不到那儿论述，非得放到太阳篇里边论述呢？是因为它需要在太阳篇里边。我在这儿给大家打个比方：你像比较好一点的电影，在这个电影开幕的前几分钟里边，一定要给你介绍时间、背景、历史、环境、主要人物和人物的性格、人物的生活背景什么的这些东西，它都用最简洁的方式都给你介绍出来。大家要注意看一看那些经典的电影作品，都有这样的特点。实际上这也是，你再看看《伤寒论》，虽然说它不是艺术作品，应该说是一个科学专著，但是，它就用了这样的手法。在“太阳篇”里，所有理法都集中在这儿示范。读好太阳篇，不仅仅是关系到读好《伤寒论》全书的问题，也包括为今后读好《金匱要略》，打下一个良好的基础。实际上以前是一本书。

另外一个问题，就是在太阳篇里，一共分了三节内容，其中最后一节论述的是“结胸”。这个内容的论述，大家千万不要认为这个东西放在这里特别牵强，这恰恰是太阳篇的一大特色。本来这个“结胸证”通过治疗方剂，通过对疾病的论述，很快就能发现这个结胸病跟太阳病，风马牛不相及，不是一种类型的疾病。但是偏偏把它用单独的篇章放在太阳篇里面，专门进行论述。我认为这是作者为了让读者更好地去理解这本书，所作的一种示范。如果我们要写这本书，我们

不能用更多的文字把它分类分得非常清晰，因为当时的历史条件就这样，在竹板上写字，能省则省。那么还必须先把理法等基础理论、基本概念都得交待清楚，那就必须把太阳篇内容写得非常全。这势必要把其它篇章里面的、其它类型疾病里典型的方证拿到太阳篇里来论述。但都拿到这里来论述，就必然会有这样的想法：这种论述是不是太乱了？那么在后面再附上一节，可以看作是后面的诸多篇。《伤寒论》里“痉湿喝”和《金匱要略》里基本上重复了，不知是怎么形成的？后面还有“呕吐下利”也是具体的病，可以把它看作是太阳篇里的像结胸证这样的延伸内容。不要认为经方里面，一方面展示了六种不同疾病类型，同时用病位病性那种具体疾病的方法，甚至是脏腑辨证的方法，去辩论疾病，不是。实际上是为了方便阅读。

而这样分类，跟其它包括《金匱要略》里面，像痉湿喝、水气病、咳喘等这类的病，虽然用这个做名字，跟这儿的结胸证是一个道理。不要认为《伤寒论》里面是两套辨证体系，不是的，就是一套辨证体系。这个结胸证就是在这里做了一个示范。为什么偏偏挑一个结胸证呢？因为结胸证是一些急性症，这在当时可能也是一种常见病，（这样做）便于读者尽快掌握这类病的治疗技术。

下面，我们简单地回顾一下整个太阳篇论述的主要内容。但是这儿，事先需要跟大家说清楚：我在准备这个资料的时候，我也大概看了看，有的专业书籍上也做太阳篇的小结，但他们的小结基本上是“流水帐”，我们尽可能避免这种方式。我们在列举太阳篇所论述的内容的时候，不求全，但求通过这个小结，能够整体地加深对太阳篇的认识，这是我们的目的。所以我们就不再去重复方证了。我们只捡那些能说明问题的，扼要地说。

首先，太阳篇里明确了一个太阳病的概念，这一点很重要。大家看，六大类疾病类型里面，只有太阳病的概念最规范。什么是太阳病？太阳病就是：“脉浮、头项强痛而恶寒”，这样的症状表现。这是它

最基本的概念，在后面我们还会一一的解读。不能再去乱延伸了，它的本意就是指的“脉浮，头项强痛而恶寒”这样的症状反应，而不是人体哪个地方得了病了，不是那个意思。

在太阳病里面，还存在着两种属性不同的疾病，这就是我们前面说过的，按现在的说法就是阳性的、机能偏于亢奋的、阳性的表证。但是这种阳性表证中，也存在着两种不同类型：一种是表虚证（桂枝汤证），一种是表实证（麻黄汤证）。那么经方理论中的表证，不是指的体表发病，或是人体病变的部位发生在体表，不是这个意思。但是很客观地说，病变发生在体表的几率多一些，所以叫表证。但是真实的意思是：脉浮，头项强痛而恶寒。以这种典型症状反应为特征的一大类型的疾病。

那么这种疾病的病理：就是人体在抵抗力不足的时候，自身没有能力去适应外面环境的变化，而表现出的一种浅表性的疾病。它既不同于其它医学说的外感病，而且也不是某种特定的外界原因造成的某种具体的疾病。在这里让大家有一种概念：经方医学和现代医学、还有传统的中医包括其他的医学，这是一个很重要的区别点。

那么其它医学的思路是：是什么样的原因，造成了人体发生了这样的疾病；现代医学找到的原因：多为像病毒细菌之类的这一类的病因；那么传统医学呢，由于当时的技术手段限制，他们就找到了一些外界的自然现象，比如说：“风、寒、暑、湿、燥、火”等等啊。

而经方医学呢，是重证，不重病因。是病毒也好，是细菌也好，还是“风寒暑湿燥火”也好，不管外界的影响的因素怎么样，或是人有没有受过这些外界因素的侵扰，只要是患病以后，表现为“脉浮，头项强痛而恶寒”，以这样的症状为典型症状反应的这样的疾病，不管你患具体身体的哪个组织、哪一个器官、或哪一个部位，发生了什么性质的疾病，只要是表现为表证的这种症状，那么在经方里面，就把它界定为“表证”。而且要用发汗解表的原则来治疗。

比如说啊，表证里边，把麻黄汤证和桂枝汤证常见的一些疾病简单一浏览，你马上就会发现：两个方剂里面都有感冒，也都有一些皮肤病，这好像是比较典型的我们常有的那种表证的理念，就是说人表皮得病了；同时还有一些妇科疾病，一些里证比如说胃炎，还有一些五官科疾病，甚至是一些脏腑疾病里边也包括一部分。这就说明什么？说明经方对疾病的这种界定，就是指的一个特定的症状群。

但是由于人体患病以后的这种情况非常复杂，所以说在经方理论里边，对疾病的治疗过程还特别地强调，强调什么呢？强调方与症状，方剂的适应证必须严格适应，才能取得比较好的疗效。那么在太阳篇里边，对这样的情况也做了比较具体和详细地举例示范。

你比如说啊，当这个表实证与表虚证（太阳病里边就这两大类型疾病），这两大类型疾病，也不是说得了表实证就只是表实证，得了表虚证就只是表虚证。有时候表实证与表虚证是错杂出现的，那么示范了桂枝麻黄各半汤；如果表虚证多于表实证，在这种情况下，给列举了一个桂枝二麻黄一汤。那么我们举一反三的话，如果说反之，表实证多于表虚证的话，有没有麻黄二桂枝一汤呢？这个也完全可以有，只要是方与证相应就行啦。

那么顺着这种思路，我们举一反三下去啊，这个方剂里边呀，特别是合方，这等于是跟我们示范了合方。那么合方的灵活度是很大的，关键是辨证是否准确。

还有另外一类情况：就是说在表证的基础上，又出现了这个基本方证之外的一些症状反应，那么这样呢，就是说基础方证，这个基础方子覆盖不了，无法完全覆盖所表现出来的症状，但是又是以表证为基础的，对于这一类的情况呢，也给示范了：像葛根汤啊，那就是表实证又伴有“项背强几几”的这一种；像葛根加半夏汤又出现呕的；像桂枝加厚朴杏子汤，在桂枝汤的基础上啊，有喘这一类症状的。

与此同时呢，经方在论述方证的同时，还强调了一个服药后护理

的问题；也论述了关于像发汗太过会造成某些疾病，某些新的变证；或者说发汗不足，会引起其他疾病的这一类的情况，也作了论述。

另外呢，特别是降一字格的条文，还列举了好多发汗的禁忌。这些都是在太阳篇里边，我们可以把它看做：这是对太阳病相关病的方方面面的论述，同时也是一个示范。对什么做的示范？对全书做的示范。

由于临床当中啊，有一部分阳性的里热证，也就是说所谓的“温病”啊，它的症状反应呢，跟阳性表证比较接近，从条文里头论述的一个恶寒不恶寒的问题。但是要如果说一旦把这个里热证当做阳性表证来治疗的话，那后果非常严重！所以说呢太阳篇第6条里边，对这一类的问题呀做了专门的论述。他用来干嘛呢？用来警示读者千万要注意鉴别这种情况。不要犯这种错误！那么至于对温病的治疗，在《伤寒论》这本书里边啊，在其他篇章里，包括太阳病的后边啊，都有专门的论述。它呢不是太阳篇特别论述的重点，但是，就是因为这种特殊的论述方式啊，他强调得非常好。

但是到后世呀，理解的时候，就是理解：《伤寒论》治伤寒不治温病。甚至出现了温病派。所谓“温病”，实际上就是里热证。你去看《伤寒论》里边，光是《伤寒论》里边，治里热的方剂就很多，阳性的阴性的，虚性的实性的，都有。

虽然说这个阳性表证啊，是临床当中发病率比较高的一类浅表性疾病，但是在实际临床当中，真正单纯患太阳表证里边的某一种或实证、或虚证这种情况啊，至少我们现在看，不是很多。最常见的是什么呢？常见的是表证与其它类型的疾病呀，或者是以合病的形式，或者是以并病的形式同时存在。

那么这个太阳篇里边，用了大量的条文和大量的方证来论述这类的问题啊。就这样呢，虽然说太阳篇确实是显得有点乱了，但是，太阳篇既展示了人体患病后的这种复杂性，同时呢，又把疾病发生发展

的规律啊，蕴含到这个方证的论述当中去。你看看因为表证治疗不当或者说是失治，比如说出现了里热证，这就跟你说了，疾病发展的规律，在这种情况下发生这种疾病，至少有发生这种疾病的可能。这不就是一种规律吗？那么整个太阳篇在论述阳性表证的基础上，它用和表证同时发病的这些常见的方证，来论述了这个经方医学当中，几乎是所有的，不同性质的疾病，这是一种手法。

另外，还有别的。那么我们现在讨论的就是说，其中的太阳篇里论述得比较多的一种类型，就是太阳病和其他类型的疾病同时出现。咱们可以简单地论述一些典型的方剂：

像这个阳性表证又伴有兼证的，就是说它还是以阳性表证为基础，但是呢，它兼了基础方剂覆盖不了的一些症状：像桂枝加葛根汤、桂枝加厚朴杏子汤、葛根汤、葛根加半夏汤、新加汤、桂枝去芍药汤等等。

那么还有呢，有以阳性表证为基础的这种方证，但是呢，病理变化也比较大，你比如说：桂枝甘草汤，相对地它就是桂枝汤的一个减方。但是呢，它非常得简，而且主治也与桂枝汤相差比较大。这也等于说是桂枝汤不能覆盖的一种情况，也可以这么理解。

接下来还有阴性表证。表证因为误治，或者说是失治造成疾病加剧，没有离开表证的病理阶段，但是陷于机能沉衰出现的阴性证：像桂枝加附子汤证、桂枝去芍药加附子汤证，这都是这一类的。

表证与半表半里同病的情况：像柴胡桂枝汤证。

表证与里证同病的这种情况：像里证属于寒的，属于虚寒的，有桂枝人参汤证；里证属于实热的有大青龙汤证、麻杏石甘汤证、麻黄连翘赤小豆汤证，等等。

表证与水证同病的，这里边也有论述。既有表实证，又有表虚证同时与水证同病的；那么既有阴性证，又有阳性证与水证同病的。就是说表证的同时，如果说同时又存在体液代谢不好的这种症状，停饮

的话，那么就是一个必须引起重视的问题。

你比如说，表实证与水证：有小青龙汤证。

那么表虚证与水证呢：有桂枝去桂加茯苓白术汤证、苓桂术甘汤证、苓桂枣甘汤证，等等的吧。

阴性表虚证与水证的：有桂枝去芍药加附子汤证，桂枝附子去桂加白术汤证。

那么要如果说我们再延伸的话，就是在太阳篇里边，不可能把所有的经方都归经，每一类都给你做一个示范。它总的有一个示范，方向性的示范就行了。

阴性的表实证与水证也有这样的方剂：像麻黄附子细辛汤证。

还有表证与血证同病的：比如第 106 条的桃核承气汤方证条文，它里边就有先解表后下血，这就是表证与血证同在。当然这里边桃核承气汤还有一个里热的问题。

在抵挡汤这个条文里边，这个也有下血乃愈，但是这个下血乃愈，有个前提条件，就是说还存在表证，但是这个存在表证的话，你可以先下血，这说得很明白。

所以说几乎各类的情况，比如说像表证与气证：像桂枝加桂汤、苓桂枣甘汤，这都是里边又参杂有气证这一方面。

你看，各种病理状态和表证，或合病，或并病出现的这种情况，几乎都涉及到了。而且呢这肯定都是例子了，他不可能全论述了，那么这整个太阳篇就成了这本书了。

这样看，虽然这个太阳篇名为“辨太阳病”，但是它实际论述的内容，远远超出了表证和它的那个合并证的这些范畴，这是经方理论的一个比较特殊的论述方式。那么在论述阳性表证的同时，以表证或者误治，或者失治所出现的变证，以这个为例子，全面地论述了经方医学的这个理论体系。同时呢，也是对这个阳性表证之外的诸多方证所做的专门论述。凡在这儿论述到的，在其它地方，或论述得特简，

或就免了，就没有了，就不论述了。

其实，我们要是从这个角度再来看一看太阳篇，再来想想这本书，在当时的历史条件下，用这样的方式来组织整个这本书的论述，其实是一种很高明的做法。但是，不足之处在哪呢？给后世的理解，带来了一定的难度，这也是事实。

那么除了上述的这种表证和其它类型疾病的这个合并证之外，在太阳病里边还论述了一些单纯的，可以说是借太阳病的这个基点，往里边深入地又论述了跟表证无关的一些疾病。为的是什么呢？为的就是让你全面地理解经方的理论体系。

你看在太阳篇里边包括了像半表半里证的：小柴胡汤证。

半表半里与里热证合并的：大柴胡汤证，柴胡加芒硝汤证。

半表半里证的阴性证：这有个问题，柴胡桂枝干姜汤证，这个呢，我们为了论述得方便，我们把这个方剂呢，把它归于咱们常说的“厥阴病”，把它归于半表半里的阴性证。因为这个方剂啊，如果说大家临床当中有所应用的话，你就会发现这个方剂确实像陈慎吾老师所说的那样，它真的有“阴证的转机”。凡是得这个方证的人啊，都真是有“机能沉衰”的那种特征。这个呢我们不妨就把它放到半表半里的阴性证里边。

其实好多方剂呀，它就介乎于那个，你说它是阴性证也行，你说它是阳性证呢，也不是说不过去，有这样的情况。就是说古人做了这样的分类啊，说起来很科学，但是，你也不要指望就是用了这么几大类型的这种病理状态，就把所有的方证，那么吻合地把它都概括进去。有的地方不是说特别工整，也没有关系啊，关键是明白里边的道理啊。能够帮助我们在辨证当中区别方证啊，只要有这个帮助，我们就实事求是地把它归一下类就行了。

还有里热证的：像三个承气汤证，白虎汤证。

还有里热证兼有水虚，就是说津液虚的：像白虎加人参汤证。

如果再延伸一下的话，它还有里虚热证啊，比如说后边有竹叶石膏汤证，就属于里虚热证啊，热证也不仅仅属于实证。

像阴性证里边属于里虚寒的：四逆汤证。

水实证里边，就说停饮：有五苓散证。

阴性的水实证呢：有真武汤证。

里实热证合并有水实的：有猪苓汤证。

像血虚证：炙甘草汤证。因为在太阳篇里边嘛，炙甘草汤可以看作是一个比较典型的血虚证。它自身这个方证里边有血虚证的因素存在啊。

那么血实证的就比较多了：像抵挡汤证，抵挡丸证。

像里实热证，与血实证，就是血瘀证合并了：这个有桃核承气汤证。

里虚寒证又合并气证的（虽然气证不多，确实有）：像厚朴生姜半夏甘草人参汤证，旋覆代赭汤证，这一类的。

鉴于篇幅，例子挑选得也比较典型，面也比较窄，没必要把相关的方证都罗列上来。但是，这些已经足以说明，说明什么？在太阳篇里边，论述了这么多的方证，这么多的典型病理状态。虽然说，这些方证，都有可能由表证发展而来的。但是，它是不是由表证发展而来，并不重要，关键是它本身不是表证的范畴。所以放在这篇里加以论述，目的就是在整个太阳篇里边，作者要全面阐述经方医学的基础理论和辨证体系。

通过对各种类型的疾病的典型方证的论述，这本书在太阳篇里边，就示范了经方里边几乎方方面面的理法。而且这儿，如果说做一个总结的话，从治疗方法上，整个太阳篇就包括了：汗、吐、下、清、和、温、补法，都有了。

在论述这些方证的同时，也论述了经方医学对人体生理、病理、医理的认识和总结。从这看，我们就能明显得感觉出来：太阳篇在经

方里边，占有非常重要的位置。既然是在太阳篇里边，已经把经方里边辨证体系方方面面都说到了，作为一个辨证体系来说，这是一个医学的核心的一部分。所以说是一个非常重要的问题。

它已经把方方面面都论述到了，我们今天做小结，就应该把这个问题的方方面面也都明确一下。因为我们在前面的学习当中，在相关条文里边，都做了一些探讨，那么这个地方我们做一个比较集中的、比较全面的、深入的，也算是总结，也算是回顾。

经方医学作为一个完整的理论体系，它的理论要点在太阳篇里边，作了比较详尽的论述。这也正是太阳篇里包括了许多太阳病以外的这些方证的一个原因所在。也是这本书的一个特点，一个论述特点。

但是历代注家，就是这种特殊的论述方法，对这种论述方式理解得不够到位，历代注家多流于理解文字的表面啊，止于表面文章。他们不做整体的、深入的解读，其结果就必然是：造成片面的理解。最后是以讹传讹。

最为典型的例子是什么呀？可能，我这地方，也想了一下，要按说应该回避这类的问题。但我觉得我们在一块儿学习，只要是对大家学习有利，我不妨把一些观点拿出来，大家可以讨论，这主要是我自己的看法。

最典型的这一方面理解的，也是最普遍的，就是“六经钤百病”。实际上这在伤寒界、理论界，这是一个非常响亮、非常有名的一个说法。就说“六经钤百病”，意思就是说伤寒论什么病都能治。说起来好像没有什么错，但是问题出在哪？片面理解经方理论体系，把经方理论这个非常完整的辨证体系，就归于六经。换句话说归于六种疾病。

不管把六经解释成脏腑也好，解释成经络也好，或解释成六类疾病也好，不管他做任何解释，实际上这种理解，都偏于片面。因为，六经里边许多病理因素涵盖不了。我不止一次地跟大家说过了。到最后会形成什么呀？有的人很机械地套，有的人也比较客观地看，这六

经就是有一些东西涵盖不了啊，比如：寒热，它涵盖不了。那怎么办呀？就往里边凑，很牵强地往里凑。到最后，把这个六经凑成什么呀？凑来凑去，凑成一个大杂烩。因为你牵强地凑进去的东西，看着内容丰富了，但是不科学。他不应该归那一类，把它勉强地凑进去，它融不进去。

那么，更有甚者呢，就是因为六类疾病当初起这个名字，跟《内经》里边经络的名字是一样的命名，所以就理解成这是经络发病，这也是比较有代表性的。

也有一些中医前辈们吧，他鉴于六经没法去覆盖许多常见的辨证要素，所以就干脆另起炉灶，就总结出了一套什么呀？总结出了一套“八纲辨证”，又自己形成了一套体系。但是，八纲辨证，我们今天再看，它仍然是建立在对经方理论片面理解的基础之上。说到这儿，面可以宽一些，八纲辨证不仅仅指的是经方，时方也用八纲辨证。时方用八纲辨证，它里边依然不包括水证，血证，气证。还是一个不全的，还是一个片面的。

还有的医家就特别强调：气、血、津液。有的像“营卫气血”吧，强调“三焦辨证”的，强调“脏腑辨证”的，等等，辨证方法层出不穷。

要如果我们今天站在经方理论体系的高度，我们做一个全面地剖析之后啊，大家会发现，所有这些辨证，都有一个共同的特点：以点带面，以缺带全，都不全面，都偏于片面。

虽然说造成了中医里边派别林立，但是中医的整体疗效，差强人意。真的，整体疗效不能令人满意。现在大家都有了这样的意识，就是说：中医要想振兴，出路就在于经方的普及。经方理论的正确理解和广泛地普及，这是中医最根本的出路。那为什么？因为其他的那些啊，正是因为没有完整地、正确地去理解经方的这一套理论体系，所以说走偏了。每个人去强调自己的那一个面，他知道的那些东西，每

一个派别都在强调自己知道的那一个侧面。最终形成一个什么样结果呢？就是说，治某些疾病比较拿手，一旦碰到他那个理论覆盖不了的那些疾病的时候，他就束手无策。所以说，临床当中就表现为时效时不效。

咱比如说，现在在这个临床，市面上这个临床大夫用得最多的，就是脏腑辨证结合八纲辨证，这是用得最多的。但是这样的话，我们仅仅从病理要素上看，他就缺少了什么？缺少了气、血、津液。气、血、津液是什么？大家看看，在《伤寒论》的太阳篇里面，就咱们学习太阳篇里边，许多方剂都是涉及气、血、津液。实际上，这是关乎到人体生理病理的物质基础方面的一些辨证要素，非常重要的。如果说用这样的辨证体系，应用于临床，说出现疗效不稳定这样的弊端，这不足为怪，很正常。

但是我们反过来说，所有的刚才我们列举这个，大家看啊，其实真正的经方辨证体系，也不外乎这些东西。只是什么啊？只是每一个人都在强调一个侧面，那么他强调这个侧面，我们正面地看：这也是他们在长期的研究和总结经方理论和中医其他理论的一个结晶，也是一些好的东西；问题就出在，我们现在用一个简单的话，就是出在不到位上，不全面，没有到位。其实啊，如果说能够正确地解读经方理论的话，在太阳篇里边，所有这些东西，已经几乎是毫无遗漏了，全面都做了论述。关键是你理解不了，那就没办法了。是不是？

下面看看经方里边是怎么论述的？经方论述的这个辨证体系，实际是什么呀？是用六大类主要的疾病类型为主线，只是以它为主线。其实太阳篇里边，所有的辨证要素的方方面面基本上都论述到了，刚才我们列举那个也很全了。那么后边的那些，像阳明病，像少阳病什么的，只是给你做一个提纲挈领性的一个，是一个方向性的，指明一个方向。里面相当一部分，等于说在告诉你，这个病，这种类型的疾病，我在这儿论述它属于哪一类的症状反应？属于什么性质疾病？具

体的治疗在太阳篇里边都有了。

实际上，这六大类疾病，太阳篇里边全都论述了。后面那些啊，跟别的论述内容实际上是一样的。为什么非得把这个六经，就因为这本书分了六种疾病，就把它弄成六经论，把它绝对化。肯定是不应该这样子！

那么这个六经的实质是什么？也就是说六类疾病。我们今天在胡老的学术思想指导下，我们再来重新审视：其实这是经方理论对人体患病以后，所表现出来的不同症状反应，所形成的不同的病理状态，他来界定疾病，界定出来的这么六种主要的疾病类型。他没想概括所有的，只是把它作为一个主要的，打算做为一条线。通过这条线上，再去延伸许多其他的辨证要素的方方面面。而且这种分类，分的是什么？分的是症状。你比如说太阳病，太阳病指的就是：“脉浮，头项强痛而恶寒”，以这样的症状为典型症状反应的这么一种病理状态。那么在这种病理状态下，为什么要总结这样的呢？因为在实际临床当中，在这种病理状态下，发生在不同的人体上，可能发生不同的部位、不同的器官、不同的组织，甚至发生不同性质的多种疾病。那么怎么办呢？他找到这条规律，又总结出这么六大类型。这六大类型比较常见，而且也比较主要，就把它作为每个章节的题目来论述。但是，这并不等于说：就包括了那里边的像血证、水证之类的。也没想去让你包括它，而且在条文里边，也论述得很明确，就有这类的情况。

实际上在当时啊，用这种三阴三阳分类的方法划分事物，恐怕是一种比较流行的办法。经方原作者把这种分类方法借鉴到这个书里边，把常见的疾病分成六类。但是六类之外还有其他的，他没想去概括所有的病理状态，实际上也概括不了。他论述的里边有嘛，就是说篇名里边没有，论述里边有，这跟太阳篇不一样嘛。太阳篇说论太阳病，但是他论了好多，里边论了好多杂病，那你还说它是太阳病吗？就是说太阳篇，是以论述这个阳性表证为主线。但是作者呢，本来应

该是论述太阳病的，但是他呢，变了一种方式，以论述太阳病为切入点，一层一层地深入，最终呢，达到了全面来论述经方医学的辨证体系的这么一个目的。

我们今天解读，我们有了胡希恕经方理论思想的指导，通过客观深入地分析和归纳总结，最后咱们再在临床当中加以验证。那么这个辨证体系啊，我个人认为吧，这个辨证体系应该是下面这个样子的：就是说，这个辨证体系里边分了两大部分，是有两部分组成。那么其一，这第一部分是什么？就是属于疾病类型的这种病理要素，那么这样呢，有了六项。

一个是表证：表证就是浅表性的这一类疾病的症状反应。你比如说像麻黄汤证、桂枝汤证都属于这类的（阳证）。那么阴性的呢？就是桂枝加附子汤证。

那么半表半里证：是比表证更深一层的疾病。这种深一层是指的症状反应深一层，而不一定是人体的具体病变位置，绝对是深一层的那些器官，那不一定的。你像小柴胡汤证或者柴胡桂枝汤证，特别是小柴胡汤证大家都比较熟悉，小柴胡汤证所治疗的病既有人体里层的病（如胃肠疾病）也有表层的病（如皮肤病），也有半表半里层的病（如肝炎），我说的是病，就是说，大概是在疾病表现或者说具体的病变位置上。

我曾经用大柴胡汤治好了一个人的粉刺。因为这个粉刺，这个病灶明显是在表皮嘛，但是他表现为大柴胡汤证的那个症状反应，你让他吃大柴胡汤，他的粉刺也好了。那么实际上这就是说，他的症状反应比那个浅表性疾病的那个“脉浮，头项强痛而恶寒”的那种症状反应属性要深一些，要深一层。

那么再深一层的就是里证：具体方剂呢咱们就不说了啊，限于这个时间的问题，大家对这方剂也比较熟悉。

第四个呢是水证：有表证、有里证、有半表半里证，再一个呢就

是水证。为什么叫它水证？大家可能比较习惯于像那种停饮啊什么的，这个叫它水证，是人体体液代谢方面出现了问题，既包括水实证方面的，也就是说停饮；也包括津液虚，津液虚也等于说水虚证。

那么第五个呢是血证：血证呢是跟水证相同性质的问题，就说它是血液方面的一些疾病反应。那么它既有阴性的，也有阳性的，有虚有实。所以没把它单纯叫做血瘀，或者说血虚。就说，总的说就是一个血证。

第六项呢是气证：这个气证呢，气证指的是什么？因为这个呢有点跟别的不太相同。一个是面呢比较窄，再一个呢就说从病性上也跟其他类型的有点不太一样。那么实际上是指的人体内部气的运行方面的一些疾病：比如说桂枝加桂汤，它有气上冲；那么厚朴生姜半夏甘草人参汤，这个方证呢，它是有严重的气滞，那就说肚子里边气很多，敲着嘣嘣的；那么旋覆代赭汤呢，气逆，它那个不仅仅是肚子里边有气，而且这气呢往上来不往下走。

这个气证啊，本身我呢也反复地考虑，它往往都伴有其它类型的疾病。你比如说，像桂枝加桂汤，它是伴有表虚证。那么要如果说是，刚才我们说的其它那方剂呢，都伴有里证，多数属于里虚证。但是因为它确实是在临床当中啊，它这个有独特的症状反应，还是把它看作一种疾病类型，比较有利于我们临床当中应用这个辨证体系。还是刚才那句话，就说经方的辨证体系，以能够合理的、尽可能地覆盖所有的方证为原则，不求它多么工整。你像这个气证里边，难以区分像阴阳啊、寒热啊，就有的可以好分，有的不太好分。不好分也没有关系啊，只要是便于我们使用就行了。它符合经方方剂的那些病理状态就行。

这是第一类。

那么第二类呢，是属于疾病性质方面的一些病理要素。那么这些病理要素呢，看啊：

第一种是阴阳：那么这个阴阳，不是咱们传统中医里边说的那些很宽泛的那个阴阳，不是那个概念。这儿的阴阳，经方里边的这个阴阳：就是指的人体机能偏于沉衰，或者说机能偏于亢奋，而表现出来的症状反应。这仅指这些，指这个范畴。所以说就不像时方那种辨证，阴虚了阳虚了，不是那个概念啊。关键是人体有没有那种机能偏于沉衰或者偏于亢奋的那种症状，关键是这个。

第二个呢是寒热：那么这个寒热，寒热的实质是什么？寒热的实质：就是人体内部温度变化，所表现出来的疾病的反应。你比如说像这个里证里边，有白虎汤证，这是典型的热证，里热证；那么四逆汤证呢，又是典型的里寒证。像这个啊，因为这种说法呢，这么提的不是很多。

但是，你要如果说仔细地去推敲，像凡是热证的，表现出来的这些症状：你比如说，脉数啦，脉洪大啦；像这个舌苔黄；像汗出啦等等。所有这些你追根求源，古人之所以把它归到热证里边，到底它还是人体里边的正常温度就是变高了，超出正常值了，它才表现出来这样的反应。

那么最容易说明问题的，你比如说有些里寒证的病家，你给他做腹诊的时候，比如说胃部这个地方，它体表的温度，都比其他的地方温度低。那你就可想而知他里边，它又没有表证，可想而知他就是因为里边温度太低了，那么所以说就造成这种情况。那么具体的病理呢，这个是人体的机能方面的，但是它又表现为这么一种以寒热的形式表现出来。

虚实：那么虚实这种病理要素，指的是什么？指的是人体，或是物质上的，或是功能上的，偏于太过或者不及的这一类的疾病反应。

因为这些要素啊，用这些要素来界定我们上边所讨论的那些疾病类型。它呢是用来界定它们，就是这些疾病性质。为什么叫做疾病性质呢？就说它是用来界定上边那些不同类型的疾病的发病趋势。所以

呢我们把它叫做疾病性质。

那么咱们举例子说啊，这样说比较抽象一些。咱以表证中的这个麻黄汤证为例子：那么这个方证为典型的阳性病里边的表证中的实证。它是阳性的、表证中的实证。如果在辨证的过程当中，你只确定了它是个表证，确定的这种疾病类型，因为没有这个表证到底发生的什么性质的病变，你还是无法确定它到底属于什么方证。那么要是如果说，你只确定了这个疾病的阴阳属性或者说是虚实的属性，那么你像麻黄汤，你能确定它是个阳性证，又是一个实性证，但是它没有具体的疾病类型，那么它是患了什么样的这个阳性证，或者说是什么样的实性证啊？你也没法确定。那么只有把这两类病理状态，你把它合到一块儿，既有疾病类型，又有确定疾病类型出现了什么性质病变的这种，要这种病理因素，你把它结合到一块儿，这个麻黄汤证马上就出来了。它就是一个阳性的表实证。假设说人真要是仅仅是患了这种单纯的疾病的话，它就是麻黄汤一个方剂能治，而且这个在临床当中它就范围非常小了。当然这里边还有一个就说葛根汤，也是从病理上跟它比较相似，但葛根汤有它自己的特殊的症状。但是在病理上呢非常接近。

那么疾病类型和疾病性质，这两大类的辨证要素，要是再交错着出现，我记得咱们讲那个桃核承气汤的时候，我跟大家在纸上画了一些斜线，把这些东西，把它连接起来，不同的方证会在不同的疾病类型和疾病性质之间，会有一些交错的这些联系。要如果再把它联系起来，就可以基本上概括经方医学所有的方证。凡是疾病，必定它得属于某种类型的疾病：或表证、或里证，或水证，或血证。凡是某种类型的疾病，又必定要有其病变的性质。就是说有了水证，到底是水实，还是水虚啊？是津液虚啊，还是停饮啊？那么得给它界定一下性质。这是两大类不同的病理要素。

你比如说啊，桂枝汤证就是阳性表证中的虚证；那么桂枝加附子

汤证，是阴性表证中的虚证。葛根汤证为阳性表证中的实证；而麻黄附子甘草汤证是阴性表证当中的实证。

那么三个承气汤证，就是大承气汤、小承气汤、调胃承气汤证，是阳性里证中的实证，实热证；四逆汤证，又是阴性里证的虚寒证。

你看啊，比如说这个，不同的疾病类型和不同的疾病性质互相之间，会出现很多的组合，这就是一个。

实际上，经方的这种病理辨证体系，看似要素不多，但是，一旦要这么详细地按照具体的方证再细分的话，你会发现是非常复杂的一个体系。

那么由于人体患病以后，这种病理状态具有一个复杂性和多样性，不同类型的疾病和不同性质的疾病，同时发生在一个人身上的这种情况，而且还很常见。这在太阳篇里边，也有充分地论述，把它称之为为什么？称之为合病和并病。

你比如说：表虚证与半表半里证合病的，就是柴胡桂枝汤证；那么表实证与里热证合病的呢，这就是大青龙汤证或者说麻杏石甘汤证；那么表实证与水证合病的，像小青龙汤证，等等。

同时呢，不同性质的这个病情，不同性质的这种类型的疾病，也常常同时出现。你比如说：桂枝加附子汤证，它既属于阴性的表证和虚性的表证，就说这里边不同性质的疾病占两个因素，它既是阴性的，又是虚性证。

而且还有一种，比较特殊，说特殊也不算特殊，就是说还有一种什么情况？相同的一种疾病的病性的两个方面，有时也会同时发生，同时发生在一个人身上。但是这种方证还很常见，你比如说：半夏泻心汤证，以半夏泻心汤证为代表的这三个泻心汤证，都是典型的例子。它属于既有寒性证，里寒性证，又有热性证，半表半里之热。这样错杂出现，都是寒热方面的属性。但是，两个相反的疾病性质可能会出现在同一个人身上，那么同时出现，就同时治，这也没什么问题。

所以说啊，经方理论整个辨证体系方方面面的问题，在太阳篇里边都以具体的方证的形式，做了比较详细地论述。如果说，我们再深入一层，再往里边研究分析的话，在这些辨证要素之间，还有些规律的东西：

你比如说，这三大类疾病性质的属性，就是阴阳、寒热、虚实。他们之间存在着什么？存在着一种递进关系。当两种不同性质的疾病趋势一致的时候，那么就表现为同一种属性。但是如果说趋势不一致的话，就会呈现出一种轻者服从于重者这种现象，这是客观事实。

具体啊，咱们也看看，在临床当中实际上很重要，也很常见，辨证的时候常常要考虑这些因素。要如果说仅就虚实而言，虚证为不及，可以视为阴证；实证为太过，可以视为是阳性。但是当虚实与寒热同时存在的时候，虚实本身的属性，随着寒热的属性而变；那么寒热之间，寒性属于这个阴性证，热性属于阳性证，但是当寒热又与阴阳同时出现的时候，寒热的属性，又随着阴阳的属性改变。

你比如说啊，表证，这个表证类的疾病，有阴阳和虚实的，这是我们刚才说的三类不同性质的疾病属性，他们之间的一种特殊关系。

下边还有一个，就说这是我自己的一个认识：表证这一类的疾病，有阴阳属性，有虚实属性，但是没有寒热属性。

那么关于这一点呢，我们在条文学习中啊，做过比较详细地说明。我不能肯定地说它就是一个多么正确，但可以供大家参考。毕竟这是我经过长时间的思索，我觉得可以得出这样一个结论：无论阳性表证还是阴性表证，凡是有寒热的，都是或者说伴有半表半里的寒热，或者说是伴有里证的寒热。你比如说，大青龙汤证、麻杏石甘汤证，它们都是在表证的同时伴有里热证；桂枝人参汤证，则是在表证的同时伴有里虚寒证。

那么如果说，表证的寒热是指病因而言，这是中医里面标准的解释。就是说表证的寒热是指：人体受了寒，还是受了热引起的表证。

但是在经方理论里边，因外界的寒热对人体的影响而发生表证的，凡是这类情况，跟人体患病以后的寒热属性没有对应关系。你不能说这人着了凉以后，就一定会发生寒性的表证，没有这种关系。你受了凉以后，照样可以发生大青龙汤证，照样可以发生麻杏石甘汤证。所以说这种把外界的致病因素，用来界定表证寒热的这种理论，应该说不符合事物的本来面目。

那么如果说表证的寒热是指体温而言，体温的高低而言，那么与症状反应又缺乏稳定的对应关系。你这个体温高，有时候也有寒证，特别是里寒证，四逆汤证可能出现体温高，理中汤证也可能出现体温高。

那么要如果说，表证的寒热是指的症状而言的话，凡是表证当中见到寒热倾向的，有这类反应的，它的寒热所反映的都是或里证，或半表半里证的寒热，都不是表证的寒热。

人体的寒热属性与表证无关，表证里面就没有这一项。我们明确这一点有什么实际意义？

在临床上，首先从理论上说：这一点是人体患病后的一个规律，这是一个事实。同时哪，在临床当中，我们在临床上遇到一个表证患者，当你辨证的时候，你辨他为阳性的表实证。你本来想投麻黄汤来着，但是，他同时又存在口干烦躁、舌苔黄等一些近似热性证的这样的症状。你这时候，对这样的患者你要马上警惕起来，警惕他是不是有里热。这就是一个麻黄汤用得对不对的问题，会不会出现误治的问题？只要是你已经确定用麻黄汤证的，你再看看他是不是有里热证，有里热的话用麻黄汤是危险的。

说到这儿，给大家说一个实例。最近看到的，我见到的一个网友发了一个帖子，是他治疗感冒的一个治疗过程：有这样一个感冒病人，先用了麻黄汤不效，又用了桂枝汤又不效。像这个感冒他不是表证吗，怎么不效呢？后来用的什么呀？后来用的张锡纯的寒解汤，一剂就好

了。那么看看寒解汤的药物组成是什么？石膏、知母、连翘、蝉蜕，这四味药。大家看看这不是白虎汤吗？那么这说明什么呀？说明他前边用麻黄汤和桂枝汤全用错了。那么说他对经方理解得不深不透的，他还会认为自己用得很规范。感冒了先发汗，先用了麻黄汤，不好的话，再用桂枝汤。但问题是，一开始就不是麻黄汤证，一开始就有里热，肯定是有里热。在那样的情况下，再得出那样的理论。

看来中医不该存在门户之见，什么方子只要是能治好病就行。问题是经方你没用好啊！当初用大青龙汤或者麻杏石甘汤的话，当然看看有汗无汗了，不一剂就好了吗？

那么从这儿就能看出什么呀？社会上众多人都在用时方，很少有人用经方。为什么呀？经方没学到家。用经方一治，治不了，然后就用时方。这不是时方很好用吗？然后再治疗，还是效果不好。

为什么中医治病整体疗效不好啊？你再往后治疗，那种中医辨证体系最终就是时效时不效。不管学什么你都得把它吃透了。如果说真的效果不好，可以抛弃它。在你没吃透的情况下，就轻易地下这样的结论，就不太合适了。

那么在实际临床当中，就像上述咱说的那样：这经方的辨证体系，用于具体的疾病治疗，还只是一个指导性的，常常你最终没办法确定具体的治疗方剂。

你比如说：经过四诊以后，辨证确定患者为阳性的里热证。为阳性里热证，你还要进一步的辨方证，最起码你还要在三个承气汤之间，进一步确定他到底是哪一个方剂的适应证。实热俱重的，为大承气汤证；实证重于热证的，为小承气汤证；那么热证重于实证的，为调胃承气汤证。这不就又分开了吗？

这里面还是辨证要素的一些变化，那么根据不同症状的表现，你再具体地分析一下。这就是我们胡老所说的：“辨证的尖端是辨方证”。这是整个经方辨证体系的最后一环，也是最重要的一环。

经方医学的这种以人体患病后的疾病症状反应，来界定疾病状态，界定病理状态，最终来确定具体的治疗方证的辨证体系，我们把它称作病理辨证。这比较恰当。

大家看看历史上对经方辨证体系，至今没有一个恰当的名字。六经辨证不合适，八纲辨证也不合适，营卫气血辨证也不合适，都不太合适。经方辨的是什么？最终辨的都是病理。这是人体处在一种什么样的病理状态，他不是一个具体的疾病。

这个辨证体系反映了经方对疾病规律的认识，用之于临床，不单单是疗效卓著，而且它具有其他任何医学无法比拟的可重复性。这是经方医学的一个非常重要的特点。

现代医学常常说中医缺乏可重复性，都是些个案。实际上经方医学的这套辨证体系，应用于临床，可重复性极高，理论上百分之百。这说明什么？这说明经方这个辨证体系，它符合事物的客观规律。其他的，某种程度的偏离了事物的客观规律，最终在疗效上就能体现出来，它的疗效就不好。

因为经方医学的理论和方法，它来自于每一个具体的方证，对方证的把握，对方证的理解。所以说要深入地理解经方医学的病理辨证的实质，我们还要解剖具体的方证，来揭示经方理论的内涵：

下边呢，我们以一个大家熟悉的不能再熟悉的方子，我们看看经方辨证体系的一些实质性的内涵：我们以桂枝汤为例，桂枝汤一共五味药，桂枝、甘草、生姜、芍药、大枣，那么桂枝汤的适应证的典型症状反应是什么呢？恶风寒、自汗出、发热、头痛、脉浮缓、舌淡、苔薄白，这是典型的症状反应。那么在桂枝汤的病理状态下，它可能发生的（我们传统中医诊断的）疾病，那么在桂枝汤证的病理状态下，在临床实际当中，它可能会发生的，中医称作什么病呢？你看啊：外感病当中的太阳中风（这实际上是经方的一个命名）：自汗，发热，风寒湿痹，头身疼痛；妇科病：妊娠恶阻，妊娠腹痛，产后发热，产

后腹痛，产后漏汗，行经感冒，经痛，绝经前后诸证；那么内伤病的：遗精，心悸；外科病的：你像肩肿，股肿，直疝；那么儿科病呢：像小儿腹泻，痢疾，麻疹；皮肤病的：像风疹，丹毒，痒症；五官科病的：像鼻塞不通，流涕不止，眼帘下垂等等。这是传统中医在临床当中用桂枝汤所治疗的疾病。

那么，现代医学也就是说在桂枝汤证的病理状态下，呈现出来的现代医学的疾病就更多了，现在我们先不说太多了，我们这儿不念了。多少呢？我统计了一下 95 种病，这还不是完全统计，95 种病。那么这些数据说明什么？我记得，我上一次单独发了一次这个方剂的这些资料哇。有人就说，这不是西医的研究方式嘛。大家看看这是不是西医的研究方式？我在这儿把这个要点给大家说一说啊：

上边这些数据，我们可以得出这么一个结论来啊，在经方医学中，方剂治疗的是：人体患病以后，所表现出来的一组特定的症状反应组合。也就是说，方剂与方剂的适应证有着稳定的对应关系，经方医学中的每一个方剂，都有自己的特定的适应范畴。

这个在经方理论当中啊，这种病理状态，正是造成各种具体病变的真正原因。也就是说每一个方证，都是一个特定的病理状态。那么这种病理状态呢，它就是造成各种疾病的一个真正的原因，这正是经方医学对人类做出的最大贡献。也就是说：现在大家不都是在找这个疾病到底什么原因造成的？不管中医也好，西医也好，一直在找这个，都在找这个。其实，经方医学早就给你找到了，不是外界的某种因素，而是人体内环境发生了某种病理上的变化。这种变化，恰恰是人体出现各种疾病的一个真正原因，这是其一。

再一个经方方剂与具体的疾病之间（不管是中医的疾病也好，还是西医的那种疾病概念也好），没有稳定的对应关系。你看这一个桂枝汤证，就可能出现各种病变的部位和病变的性质完全不同的多种疾病。这说明什么？说明经方医学找到了通过人体患病后的症状反应，

来治愈各种疾病的一个通治方法。

那么再一点，就是通过上边这些分析啊，咱们从经方医学的辨证体系中，我们可以延伸出一系列的不同于其它任何医学的一些医学概念。这都是基础性的、方向性的东西。

你比如说啊，我在这儿举几个例子：一个是同一个病理状态下，可能造成不同的疾病；这个大家慢慢去体悟啊，刚才桂枝汤这些数据呀就充分说明这个问题。再一个部位、病性完全不同的疾病，有可能是在同一种病理状态下发生的（这在好多医学里边感觉是不可思议的事）。但是在经方里边这是一个最基本的理念，你必须得能看懂这个理念。不然的话，你就等于说你没掌握经方医学。

病位、病性完全不同的疾病，如果用经方理论辨证为同一种病理状态的话，可以用同一个方剂治愈，这也是一个非常了不起的事。

还有具体的病变位置和疾病性质，只是疾病的表象，在经方理论里边啊你看去吧，所有的，包括那个《金匱要略》里边说的具体的一些病，这些都是疾病的表象。而只有通过症状反应所表现出来的病理状态，才是疾病真正的病因。还有，在经方理论当中，疾病的概念实际就是：某种病理状态下的某方剂的适应证。这就是疾病，这就是经方疾病的概念。

虽然说在《伤寒》里边和《金匱》里边，也都有那个以病名分篇的这种情况，但是，那是为了方便阅读而设的，它改变不了经方辨证施治的实质。比如《金匱要略》里边的奔豚病：奔豚病它说是一种病，但是治疗的过程当中，根据表现症状的不同，有奔豚汤，有桂枝加桂汤，是不是？还有苓桂枣甘汤。这为什么用不同的方剂治呀？因为表现的症状不同。那么，同一个病还有什么作用嘛？就是因为它有气从少腹上冲胸咽的这样明显的症状反应，把它放在一个疾病里边让你用着好用，学着好学，就这么来的。

那么要如果说从这种思路你举一反三，经方理论可以延伸出许多

独特的医学概念和规律。所以说我在这儿，今天晚上恐怕我说的最多的一个词，就是经方医学。我们把它称作经方医学，它不同于其它的任何的一种医学。

虽然说从表面上看，经方医学它治疗的只是疾病的一种表象，因为症状反应嘛，最容易获得的一种疾病的信息。但是，数千年的这个医学研究和临床实践证明，经方医学找到了通过人体患病后的症状反应，来判断疾病本质的一个正确路径。并在这个基础上，研究总结出了一整套可以高效地对应各种疾病的通治方法。这就是经方医学的伟大之处！

通过上边的分析：我们可以看到，太阳篇实际就是以阳性表证为线索，集中地阐述阳性表证，并且示范了经方医学整个辨证体系，所有的辨证要素和方法，以及治疗原则。治疗原则它都在太阳篇当中，用这种阳性表证因为误治或者施治以后，所发生的各种变证的这种方式，并且蕴含在一些具体的方证当中。它用这种方式做了详尽地论述，都包括了。

你看我们刚才说了那么多，其实依据的都是太阳篇里论述的内容。所以说太阳篇实际上囊括了经方医学所有的基本理法。其中既有经方医学对人体生理病理的认识，也有治疗所有疾病的一个基本法则和方法，它更包括了这个常见疾病的治疗方剂。

所以说这个太阳篇啊，是整个经方理论的一个基础和核心。它为我们正确地解读此后《伤寒论》的其它内容和《金匱要略》的所有经方内容，提供了必要的理论基础。

辨阳明病^①

注：《宋本》作“辨阳明病脉证并治第八”。

胡希恕：在这个里位上啊，就是这一个…啊，所谓胃肠之里这个里呀，它也有两种病：一种是阳明病，一种太阴病，啊。那么那一个…这个阳明病它就是里阳证，太阴病就是里阴证，啊，就是病邪反应在里，而现出来的阳性症状者。那么 古人，他是，认为这是，啊，由经络受病，那么，实质呢，不是那么个事儿，啊。咱们看看他这个书源起怎么讲的。

李冠杰：阳明篇在《康平本》的篇名叫“辨阳明病”；在《宋本》里边，给改成了“辨阳明病脉证并治第八”。应该说《康平本》里边的名字，更贴近经方理论的本意。

因为阳明病的上半篇，顶格条文比较少，我们就采取能把意思大致说清楚的原则就行了，重点的地方，我们会重点的解读一下。一般的尽可能地减少重复，像小结什么的，能省就省了。

问曰、病有大阳阳明、有正阳阳明、有少阳阳明、何谓也、答曰、大阳阳明者、脾约是也、正阳阳明者、胃家实是也、少阳阳明者、发汗利小便已、胃中燥烦实、大便难、是也、（179）

胡希恕：问曰：病有太阳阳明，有正阳阳明，有少阳阳明，何谓也？答曰：太阳阳明者，脾约是也，正阳阳明者，胃家实是也，少阳阳明者，发汗，利小便已，利小便不是利小“利”啊，他那个…那…

那是个错字，是个“便”字儿。利小便已，胃中燥烦实，大便难是也。那么他头一节啊，他是…说明这个由太阳病转属而为阳明病，就是由太阳病的表证，它传里而发生阳明病，可是太阳病还存在，也就是咱们说那个太阳并病，太阳阳明并病；那么少阳阳明呢，也就是说的是少阳阳明并病，这个病啊，由少阳传入里，而并发阳明病，啊。所以他这个书啊，特设问答来解释这几个问题。他说阳明病，啊，有所谓太阳阳明者，有所谓少阳阳明者，还有一种正阳阳明。这是，啊，指着什么说的呀？他底下，啊，就解释了。他说“太阳阳明者，脾约是也”，什么叫脾约呢？这是个病名，后头有，啊。我在这儿给解释一下子。他古人这么样子来看法。他说这个胃呀，这胃消化之后，那么把这个，这个脾呀，为胃行津液，他古人这么个看法。古人对这个气的形成，说“气出上焦”嘛。我们饮食入胃，那么这一种有啊…这一种营养成分呐，啊，它是由胃和肠子的作用，古人他看的他只是就看着一个胃，啊。那么消化成熟的东西，经过血管吸收了，古人叫做，啊，血，红嘛。所以“其精者，色赤者谓为血”，色赤，红，就是到血管里头。这是在《内经》有这个话。那么这个气的形成，他也知道这不成。这个气的形成啊，必须到肺，啊。那么呼吸到这个空气里头这一种，啊，所以，古人说“受之于天”，那个天那就指着天气说的。《内经》那个注解呀，给说的是“先天之气”，那个不对的。所以说，水谷化合物，啊，再吸收这个天的气。在哪儿吸收啊？他得在肺这儿。那么古人来这儿他没看明白。他说这个胃消化完了，怎么跑到这个肺上去了？哎，所以现在大家也解释了，就指着血管吸收了，啊。其实古人他不是这么个看法。古人说是脾，脾有这个作用，能吸收，啊，送到肺上去，他是这么看的。所以说这个脾为胃行津液。总得这个，我们吃的东西这个营养成分总得加上空气的这个氧气，搁着现在说了，啊。这一个对人身上这个营养成分才是满足，啊。那就咱们所说的这个，啊，经过肺…啊，这种这个…这个气的交换之后了，

是吧？他古人呐，他 是这个他是没办法，他限制于…他也瞅不着，是吧？他就心思这个这个作用啊，是归于脾，脾为胃输送津液到肺，这这个时候才能与天…啊，这个天气才能够接触的。怎么叫做脾约呢？他是这胃中燥，啊，干燥了，没有津液可以运输啊，这个脾的…它受了制约了，就指着胃中干，大…啊，大便结呀，啊，大便硬。他说这脾约了，脾呀，没有津液可行了，是吧？它受了制约了。那么这一种证候啊，古人叫做脾约证。也是大便不通，但是这个不是由热作成的。那么这一节儿他说明什么，怎么太阳阳明叫做脾约呢？这个太阳阶段呐，这个太阳病的治疗是以发汗为原则。那么在这个太阳病这个期间，由于发汗而亡失津液，啊。那一个大便硬他叫做脾约。那么这也是一种里实啊，啊，所以属于阳明病。所以这一种阳明病由太阳转属阳明，但是他这个言外这是太阳病还没罢呀，但是大便不通了，这就叫做太阳阳明，所以说个“脾约是也”。正阳阳明者，专就阳明病来看，就是没有太阳和少阳的这一种，啊，啊…这种证候存在了，只是阳明病了，那就是“胃家实是也”，啊。所谓胃家实就是这个病邪充实于胃，叫胃家实。这是我们根据这一个意义上来理解。这个胃家实也的确有证候的，就是我们按这个胃的这个部位，就是心下这个地方了。那么的确满，啊，拒按，按之痛，这都属于胃家实的一种证候，那么这咱们也就说是这个胃家实的腹证了，啊。那么这一个呢，啊，专就胃家实来看，这就所谓正阳阳明，这就是里头没有表证和半表半里证。少阳阳明者，跟太阳阳明一样了，由少阳而转属阳明的，这个少阳病不能发汗，啊。 我们后头讲了少阳病就更清楚了。他说在这个少阳病这个阶段，由于误发其汗，或者是利小便“过”，啊，那么，由于这一种错误治疗之后，胃中燥、烦、实，那么夺取这个…啊，这个津液亡失，胃中水份也被夺呀，这个胃中燥。那么胃中一燥人就烦，所以阳明 病那个烦呐，这也是个证候了，啊。同时里头也硬了，也实了，啊。大便也不通了，这就叫做少阳阳明。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边，是降两字格排版的条文。

这个条文以问答的方式，论述了阳明病三种发病途径：

其一，是由太阳病或者误治、或者失治，发展为阳明病的这么一种情况。他用“脾约”来阐明太阳阳明的这种途径发病的机制。简单地说：“脾约”就是指因为胃肠内的津液虚损，而发生里实热证的这么一种情况；而且所谓脾约还有一个典型的症状，就是大便干燥，干结。但是在整个经方理论里边，所有论述脾约的这种条文，都是降两字格的条文。但是在经方理论里边，没有这种概念，这应该是降两字格条文的作者，根据自己的理论观点，对太阳阳明所做的一种解释。

第二种情况：是人体直接发生阳明病，既没有明显特殊的原因，也没有其他类型疾病的存在，属于单纯的阳明里实热证。对这类的情况，这个条文借用了顶格条文的论述，解释为“胃家实”。

第三，是由于少阳病经过误治而发展为阳明病。少阳病的治疗原则：既不可汗又不可下。如果误以汗下的方法治疗的话，很有可能会发生变证。而且在这个条文里边的论述，不仅有误汗的治疗，同时还有“利小便已”这个因素。如果少阳病的同时，存在停饮证的话，应该利小便，但是要没有体液代谢不良的情况，利小便也属于误治，只能徒伤人体的津液，因为本身没有停饮嘛。如果津液损伤严重了，也有可能发生阳明病。

理解这个条文重点在哪呢？重点在于造成阳明病的这么几种途径。那么发生了阳明病以后，还有没有或太阳病，或少阳病的存在，在条文里边也不是论述的重点。因为经方理论不重病因，有是证就用是方。有那个症状就用相应的方剂治疗，没有，就不用。

这个条文里边，太阳阳明，正阳阳明，少阳阳明。这个东西在经方理论里边，有是证用是方，这一类的病名根本就没有太大意义。

阳明之为病、胃家实是也、（180）

胡希恕：我们研究阳明病就是，啊，我们说是里阳证了。那么就是研究病邪充实于胃的这么一种病，啊。这个实和热都属于阳啊，所以这就是阳明病。那么也就是，我们这一章书，就是辨阳明病了。头前儿他是根据这一个，啊，阳明病有这么些不同的来历，他说太阳阳明，正阳阳明，少阳阳明。这一节儿，他就…我们这一章，什么叫做阳明病？就是胃家实，是吧？你太阳阳明也好，少阳阳明也好，那么都得有胃家实的这么一种关键的证候，才能知道太阳阳明并病、少阳阳明并病、正阳阳明更不用说了。要是胃家不实呢？这一个“实”要活看。我方才说那一个按之满、拒按、痛那是一个就证候上来看的。这一个就是邪实于胃肠，而发生阳性证候者，就叫胃家实，可以这样子理解，啊。他说是啊，总而言之，所谓阳明病就是邪充斥于胃肠之里的这么一种病。

李冠杰：这个条文是个顶格的条文。

咱们解读一下：

在经方理论当中，阳明病就是指的：机能偏于亢奋的阳性里实热证一类的病理状态。这个条文里边，仅仅用了一个“胃家实”，来概括整个这么一大类型的疾病，太简了。但是如果对阳明病的典型的方证加以分析，你会发现，这反倒是比较高明的总结性的概述。

因为什么呀？因为经方里边，所有类型的疾病，实际上都是指的某一类方证。那么方证呢，都有具体的症状表现。下边逐渐地分析：

这里边“胃家”，一开始读的时候，往往都觉得挺奇怪，实际上，分析到位的话，用得挺精妙的。但是对于这个“胃家”，多数的历代的注家，都尊《内经》解释，《内经》有这么一句话叫：“大肠小肠皆属胃，是足阳明也”。都解释成足阳明胃经。

那么这样呢，“胃家”，也就成了胃及大肠小肠，用现在的说法，就是整个消化道。如果，原作者真有这个意思的话，那么这个“家”

字，在这儿并不太恰当。何必用“家”呢？你用“脾胃”行不行？你用“胃肠”行不行？都可以的。又不是说那时候没有这个字，比“胃家”更贴切一些。甚至说啊，仅用一个“胃”字也比这个“胃家”表达得还要准确一些。这个“家”呢，要如果把阳明病视为是整个消化道的病位的话，那么这个“家”好像在这个地方并不太恰当了，完全没有必要了。

在经方理论里边，所有的疾病都是以症状反应来界定的。跟脏腑、跟具体的病位没有关系。

所以经方理论，都是以症状来界定疾病类型的，实际上经方的所有的疾病类型什么的，基础都是方证，以方证为基础。整个经方理论的核心也是方证。如果大家有兴趣的话，再去看看《金匮要略》，《金匮要略》里边，分得好多那个“肺痿”，或者“水气病”，明显就是指的病位，但是再看里边具体的，还是证，都是证。

所以，我们先明确一个事儿，这个条文里边的“胃家实”，不会单纯地把一个阳明病说成完全就是发生在肠道里边的疾病，不会是这样的。那么为什么会这样的？我们应该正视一个现实的情况：就是阳明病与胃肠的实热证、特别是实证，关系比较密切。所以说呢，在这个地方找来找去，就用了这么一个字眼。

下面，看看阳明病里边几个典型的方证，就比较容易理解“胃家”指的是什么了。比如大承气汤证，它的病理特征是典型的阳明里实热证，实热都比较盛；还有小承气汤证，它的病理却是以里实为主了，以实证为主，热证在其次，甚至热证有时候表现得不是特别明显；还有一个方证就是白虎汤证，它的病理是以热为主。这三个方证都是阳明病里有代表性、典型的方证。但是无论是病理上，还是症状反应上都各有侧重。试想一下，让我们用一句比较精练的话，把这三个方证的主要特征都概括起来。不要说往竹简上书写，条件那么落后的古代，就是今天让你总结总结，你也觉得这是一个非常棘手的事。大家可以

试一试，你把大承气汤证、小承气汤证和白虎汤证，这三个方证有内在联系的、有共同属性的东西，你把它总结出来试试。

说到这儿，回过头来再看看“胃家实”，指的就是实证而言。那么为什么这儿没有用“里实”，而用了“胃家实”呢？因为阳明病，一般没有消化道内的虚证，这种情况比较少。可能说到这儿，大家可能会感觉到，怎么可能没有呢？比如，白虎汤证，如果跟三个承气汤证比较的话，应该相对的是一个虚证。但是就是白虎汤证，如果说存在着胃肠里虚，特别是虚寒的情况，要让他服白虎汤的话，特别是服的时间稍微长，十有八九，他得闹情况。

实际上像白虎汤这一类的，甚至包括竹叶石膏汤，专门治疗虚证的，也不能存在胃虚的情况。消化道里边虚的话，你喝点竹叶石膏汤试一试。里边有人参什么的，你吃吃试试，也会不好受。

我们还要考虑另一方面的因素，所有的阳明病的典型的症状反应，在具体的方证条文里边，都有比较详尽的论述。那么这儿呢，他要用一个简洁的方式，最终选择了择要而论，从简，择要而论。

那么，我们再看看其他篇里边，也有这种情况。少阳篇提纲：口苦咽干目眩。典型的小柴胡汤证，好多症状实际上概括不进去。因为提纲在那些方证里边没有论述，而且，在少阳病里边出现的机会比较多，就把它放在这儿了。

总地说，我们如果按照今天书写的这种标准，衡量古人的这种著作的话，不管怎么解释，总是都要感觉有一点别扭。为什么？因为他当时受条件限制。但是，前提条件是你要明白他的真实意思是什么？白虎汤证，甚至包括大小承气汤证，有时候治的一些病，跟胃肠没有关系。白虎汤证还能治感冒呢。所以，你要是把阳明病理解成就是消化道内的疾病，那你的辨证思路就会受局限。它实际上就是症状，就是阳明病的这些方剂的一个总和。但是不太好总结，实实在在的就是这么一种情况。

下面做个小结：阳明病是指以阳性里实热为病理特征的一类疾病。

问曰、何缘得阳明病、答曰、太阳病、发汗^①、若下、若利小便、此亡津液、胃中干燥、因转属阳明、不更衣、内实大便难者、此名阳明也、（181）

注：“发汗”《宋本》作“若发汗”。

胡希恕：他说为什么，啊，发作阳明病啊？他底下也是作一个问答来解释。答曰，他说太阳病那个阶段，我们病之初作，大概都发生太阳病了，太阳病咱们讲过了，啊。“若发汗，若下，若利小便，此亡津液”，那么在太阳病阶段，经过发汗或下或利小便这些方法的治疗，那么这一种方法治疗啊，都足以“亡失津液”，啊，亡失人的这个身上水分了。那么水分大量亡失，那个胃里头它也干，啊，胃中水分也被夺嘛，所以“胃中干燥”。这就是要转属阳明，“因而转属阳明”。转属阳明他大便就要硬，就拉不出屎来了。“不更衣”，古人呐，管这个大…啊，他…如厕，啊，他叫“更衣”，换衣，换这个，啊，衣裳。所以这个“更衣”啊，就是“大便”的一个互词了。“内实大便难”，内实就胃肠里头实，大便难，啊，排不出便来，这就叫做阳明病。“此名阳明也”。他说，阳明啊，他是举一个例子。他说，这是由太阳病转属阳明，他举这么个例子，啊。

李冠杰：这条是一个降两字格的条文。

条文中“发汗”在《宋本》里是“若发汗”，这个字应该是漏掉了。

下边解读一下：

这条也是用了一个问答的方式，论述了造成阳明病的另一种原因。它大致意思就是说：问阳明病是怎么得的呀？就回答本来是太阳

病，但是经过发汗、或者泻下、或者是利小便等方法治疗以后，造成人体津液虚损，那么消化道内水分不足，而引发了阳明病。

这里的“发汗”，应该是指方与证不太相应或者是指发汗太过而言；泻下肯定就是误治了；利小便如果是在人体没有停饮的情况下，也是多余了，方与证也不对应。这个条文对阳明病的一个典型症状做了比较详细地论述。

“不更衣”指的是不大便。

实际上，这条是对第 179 条所谓“太阳阳明”病（即开篇第一条）的一种详细地论述。这只不过是导致阳明病的多种途径中的一种。在太阳篇里对这类疾病论述得比较多，是作者对这类的条文又做了进一步地解释。

问曰、阳明病外证云何、答曰、身热汗自出不恶寒、反恶热也、（182）

胡希恕：“问曰：阳明病外证云何？答曰：身热，汗自出，不恶寒，反恶热也。”那么这个阳明病，要是…这个阳明病“但热不实”也有啊。你像咱们讲过那个白虎汤，那也是热结于里呀，啊，但是他不实。不实，这个胃家实的这种证候他不显的。我们方才说的那个，啊，心下满、硬、按之痛，这都说明这一个，啊，胃家实的一个腹证。他要是只热不实就没这个腹证，你就看不出来。那怎么办呢？啊，他又提出一个外证。他说内里有热，啊，那这个也现于外呀。“身热、汗自出”，这个阳明病这个热呀，身热，啊。他从里往外热，它不像那太阳病，太阳病是“翕翕发热”，这个热呀，在身上，啊，它是合而不开呀。就像这个热呀，在身上笼罩似的，啊。“翕翕”，翕翕就是合而不开的意思。合羽之为翕嘛。它一个“合”字搁个羽毛的“羽”。这个阳明病呢？它不是。身热，他这热由外头来的，外边儿拿手摸滚

烫，是吧？“汗自出”，它这个热由里头出来呀，它蒸人的这个组织里头这个水分，他出汗。所以他蒸蒸发热。那个古人形容这个阳明病啊，“蒸蒸发热”。你像咱们这一个，拿这个锅蒸东西，啊，他这个热是由里从外出，所以蒸蒸发热，啊。外边烫，同时他还有蒸热汗出。

“不恶寒，反恶热也”，太阳病它是发热恶寒，翕翕发热，还怕冷。他阳明病呢？他就不是了。他不恶寒，反恶热。那么这一个与我们头前儿讲这一个，啊，啊…温病是一样的。他这没说渴，当然他里有渴。那么这个热在里呀，这个刺激特别凶，啊。所以阳明病这个热比太阳病那个热，热的多。那么这一种热的，啊，刺激特别强烈，这个恶寒呐，反到受了抑制了。这是在这个大脑皮层的关系。你们可以参考参考，看看那个巴浦洛夫学说就知道了。这一种…人身上对这种刺激的这种，啊，这一种反应啊，常常的一种，啊，过于这个使着兴奋的这一种刺激，其他的刺激啊就能受到抑制的。这个巴浦洛夫他有很多的例子试验，啊，你们可以看一看。那么这一个，阳明病他身热，他也必然感到外头冷啊。但是他由于这个强烈的热刺激，这一个…这个冷他自己不感觉了。那么也就是说…说明这一个问题。我们在临床上啊，遇着胃家实当然是阳明病，即刻没有胃家实的明显证候，而有“身热，汗自出，不恶寒，反恶热”，也是阳明病。这个阳明病同时有两个特征。咱们讲太阳病“脉浮头项强痛而恶寒”一个特征，啊。因为它在表，它，啊，它没有其它的东西，啊。这个阳明病他是有两个，只热而不实，热是里…里热是相当热了。但是呢，他没…没达成这个实结在里头，那你摠，摠不出来的，是吧？那你只能就外证看。所以我们在临床上啊，这个阳明病胃家实当然是阳明病，即刻没有胃家实的证候，而有，啊，他这个外证，也可确诊为阳明病。也不会错的。

李冠杰：这也是一个降两字格的条文。

这个条文论述了阳明病在人体体表常见的症状反应，就是“身热，汗出，不恶寒，反恶热”，但这只是一般阳明病的一种常见的症状，

还有一些特殊情况下也有例外的，比如白虎汤证，有可能会出有恶寒的症状，甚至是四肢厥逆的情况。而且在后面的条文里面还有论述，阳明病初得的时候，有时候也会出现恶寒的症状。

对于阳明病的这种常见的症状，在太阳篇里面也有论述。第6条说的“温病”，实际上就是阳明病，里面就有“不恶寒”这一类说法。

阳明病，是一种典型的阳性里实热证的病理状态。这个病理就是：人体处在过度亢奋的状态下，整体的循环和代谢过程都较常人加快，直接造成体内环境温度的升高，为了维持体内环境温度的正常状态，人体就会用加快体液代谢的方式来代偿，散发体内过度的里热。其结果就常常会表现为汗出，或者小便频数，或体温升高。但是由于体内温度过高，所以即使体表的温度升高，与环境的温度加大了温差，人体主观上也不会感觉怕冷，这点与表证不同。胡老援引了现代医学研究的观念，也是比较客观的。

这一类的症状反应，无论是以里热为主的白虎汤证这一类的方证，或是以里实为主的承气汤这一类的方子，都可能会出现。当人体的亢奋状态达到或是超过了人体内脏器官所能承受的范围的时候，人体反而可能进入一种抑制的状态，整个的循环系统和代谢反而一下子降下来，这时候就会出现在辨证上说的“热深厥亦深”的情况。我们分析这些有什么意义？我们对这一种疾病反应，做尽可能全面地认识，在临床上有实际意义。实际上这也是用好经方的重要一环。

怎样才能做到“活用经方”？就是对病理有一个深入地了解之后，才能达到这种境界。比如这个条文里面论述的“发热汗出”，临床当中，有时候患者来你这儿看病，他的主诉就是汗多。我前两天就碰到一个小伙子，三十岁左右，他的主诉就非常简单，就是老爱出汗，以前就比一般人出的汗多，现在吃饭的时候，大家都一样的吃饭，都不出汗，就我自己有汗，我是肾阴虚呀！他还感觉现在不如以前体质好

了，并且想到了是不是虚引起的。我最终给他的以白虎汤加人参汤为主的方剂。

其实有汗出这种症状的，在经方的方证里边很多，像桂枝汤证、麻杏石甘汤证、越婢汤证、白虎汤证、承气汤证，甚至那种阴性证里的像桂枝加附子汤证，四逆汤证都有可能“汗出”这么一个症状出现。你仅仅凭一个汗出，根本就无法去确定具体的治疗方剂。得弄清这个“汗出”，是属于哪一种类型的疾病，或是表证桂枝汤证，或是里证，或是半表半里证。然后再辨在这一类型的疾病当中，它属于什么性质的疾病，最终你就很容易辨到具体的方证了。如果不能确定这些病理因素的话，也就等于说辨证没有了方向。

我现在老跟大家说这个病理辨证啊，这是我们辨证能保证正确方向的一个前提，对这些东西必须弄清楚。为什么经方人人都说是经典，到最后把它束之高阁，用的人少之又少？就是因为在对病理辨证这一环节上，要么去搞脏腑辨证，要么去搞经络辨证了，等等的吧，都不是经方本来的那种面目，也就是说方向错了！

如果想确定这些病理因素的话，在“汗出”这个症状之外，你还要去寻找，能够来确定病理状态的一些新的症状。比如一个患者表现出来，在汗出的同时，有脉浮缓、舌质偏淡、苔薄白，恶风寒，发热这类的症状。这不是桂枝汤证吗？这些症状就说明了这个人就处在阳性的表虚证的病理状态。

如果他在汗出的同时，又伴有舌红，脉洪大而滑数，口干舌燥，渴欲饮水，舌红苔黄这一类的症状的话，那么他就是阳性里实热证伴津液虚的这种证，具体就可能是白虎加人参汤证。

这些都是经方里面明文论述的，当你了解到他的病理之后，有一些条文里没有论述的症状，你自己就知道把它放在哪儿。就说感冒吧，现在流行性感冒非常多，如果出现往外呼的气，有一种热感，鼻腔感觉到灼热感，那他肯定有里热。尽管这个在方证里面没有论述，但是

这个症状已经明确告诉你，他有里热。那你再去找别的症状，这就给你确定了在病理上一定有里热的存在，这就是经方医学的病理辨证，在临床辨证当中的作用。

问曰、病有得之一日、不发热而恶寒者、何也、
答曰、虽得之一日、恶寒将自罢、即自汗而恶热也^①、
(183)

注：“即自汗而恶热也”《宋本》作“即自汗出而恶热也”。

胡希恕：“问曰：病得之一日，不发热”是应该“不恶热”，把它改了。你看看后头就知道了，“汗出而恶热”，啊。所以这个它应该是恶热，在成无己那个本儿啊，都是“恶热”不是发热，这个“发热”是印的时候错了。他说这个病呀，也有这样的。开始第一天，他一得的时候啊，他不恶热而恶寒。这与这阳明病这个外证，这不相符了。这是怎么个事情啊？答曰：虽得之一日，恶寒将自罢呀，即自汗出而恶热也。他说是的，啊。尤其这个病传常有，我们在太阳篇也讲过，尚微恶寒者，外未解也，啊，他由太阳病传来，他太阳病这个基础就是发热恶寒，那么他开始传，他没全陷于里，还有表证，还是恶寒。那么就是温病也如此的，啊。温病开始得呀，他那个热刺激没达到那么一个，啊，那么一个程度上，还觉着外头恶寒，但是很快，啊，温病他是内…里热盛嘛，他马上他就要热。这个热达到那个程度，恶寒就没了。他这一段就说的这一个，啊。他说，虽然得之一日，啊，有这个情形，啊。是不感觉恶热，而还恶寒的。但是啊，很快这个恶寒就没了，就是一味恶热了，啊。所以这一个，这一种情形也不得不知道啊。那么传变当然是，我们头前儿都讲过了。这一个温病开始也有恶寒一点，那吴鞠通，你看吴鞠通那个《温病条辨》不就是嘛，看恶寒他说吃桂枝汤，那是错的。这个病也不能吃桂枝汤。同时他这个，

是温病一来他要渴，嗯，那么这有点儿恶寒马上就没了。

李冠杰：这是一个降两字格的条文。

条文当中这个“即自汗而恶热也”，那么在《宋本》里面呢，是“即自汗出而恶热也”。

“不发热而恶寒者”，那么在有的版本里边，是“不恶热而恶寒者”。

这个条文，论述的是阳明病当中的一种，也是比较特殊的一种情况。大致的意思，就是阳明病初得的时候，表现为不发热，或者“不恶热反恶寒”。这是由于疾病初发，尚未达到“不恶寒，但恶热”的那种程度，随着病情的发展，恶寒的症状很快就会停止，进而表现为“自汗出而恶热”的阳明病的症状反应。

从论述的情况看，这里边暗含有太阳病发展成阳明病的时候，太阳病的病证还没有彻底结束，有那么一点意思。但是这个并不重要。

那么临床表现，实际上还要复杂得多。比如大青龙汤证的病理是什么？是阳性的表实证合并里热证。但是，大青龙汤证多表现为严重的恶寒，恶寒很厉害！虽然不是所有的患者都这样，像体表停饮为主的，就没有这么严重地恶寒。他为什么恶寒这么厉害？原因就是表实证太严重了。

麻杏石甘汤证：虽然也是类似的病理，有表证，又有里热证。但是，它的表证不如大青龙汤证严重，常常表现为恶寒不明显，甚至有时候会表现为恶热，而且还有汗出。麻杏石甘汤证的恶热，也并不能说明他没有表证。为什么会出现恶寒不明显呢？就是因为里热比表证比重要大，所以造成了恶热不恶寒的这种情况。

问曰、恶寒何故自罢、答曰、阳明居中、主土也、万物所归、无所复传、始虽恶寒、二日自止、此为阳

明病也、 (184)

胡希恕：184，恶寒何故自罢？答曰：阳明居中，土也，这个“主”字儿也没有的，他后边儿这个注也…也说了。万物所归，无所复传。始虽恶寒，二日自止，此为阳明病也。他也又…也是作一个问答解释。他说，他太阳病恶寒他怎么不自罢呀？啊。这个阳明病为什么开始恶寒，他这个…他就自己就不恶寒了呢？他底下，古人这么一种看法儿，啊。古人说是啊，阳明居中，啊，他是属土，他是这么样子来看。这个土是万物所归呀，啊。那么，他说这个寒呐，一进到这个阳明，就是…啊，进到阳明经了，古人这么看法了。他就化热而恶热不恶寒了。他这个寒，你看看这个，太阳病发热恶寒，他古人认为这个阳…这个伤寒病啊，这一种热病啊，全是伤于寒，这个寒是个邪。所以在太阳病这个寒也能传到半表半里，啊，他本身这个寒也老存在的。那么到这个少阳病呢？他也往来寒热，他这个寒也不是整个没有了。唯独到明病这个寒就没有了，啊。怎么的呢？它归土了。他古人这么个看法，这个看法是不是…啊…对，这是成问题的，啊。那么这一种事情，你看那个，在西医你看他对这个病的解释啊，他一种寒热，寒热的，啊，发烧的这一种形状，啊，啊…等等的，他不作解释。他说这个病啊，就有…就有这么个过程。这古人是什么都要解释，啊，这个开始恶寒，完了，寒没有了，这什么道理？他这个解释啊，就是这么个说法。这一个还是我头前儿我说那一个一样的。他那开始恶寒呐，他这个热，啊，热刺激，给这个大脑啊，没达到那么一个，啊，亢奋的那么个程度。要是达到那个程度，他这寒绝对没有了，啊。他古人呢，他是这么说的，他说这一个，这个胃呀，这个阳明胃，啊，它是居中属土，这个土呢，是万物所归，什么东西到这儿也都可以化了，没了，啊，他说这寒不会存在的。他这么样子来解释的。这一个解释，啊，我们可以留在后头讨论。说研究中医呀，那么有的是精华，有的是糟粕。那么这一种这……这一种解释呢，找不出什么特…特殊的

证明，我认为这就是糟粕，是吧。

李冠杰：这条是降两字格的条文。

这条实际上是上一条的续论，是对阳明病“不恶寒但恶热”这种症状的机理所作的解释。大致的意思是说：在中医的五行理论中，脾胃属土，土又为万物所归。所以阳性病发展到阳明病阶段的时候，就不能再进一步的传变了。虽然初得的时候有恶寒，但是具体到了第二天就会消失了。

由于历史的原因，我们现在学习能见到《康平本》。但是一九四七年以前，大陆上几乎没有人见过《康平本》，宋代谁见过现在已经不得而知了。也就是说，我们现在看到的所有解释《伤寒论》的注家，真正见过《康平本》的非常少，所以对条文的解读也是多种多样的。应该说《宋本》是一个最善本，以《宋本》为蓝本读的话，就认为这条和其他条文是同一个作者作的，分不出来出自不同的作者，都拉平了，这样就误导了许多读者。

对这条的认识，大致可以分成三种情况：一种是完全认同这个条文意思的，比如《医宗金鉴》就是一个代表；另一种，是对这个条文的理论观点部分认可，有一部分不认可的，比如曹颖甫，他是一个比较典型的注家；还有一种，就是对这个条文持否定的态度，以胡希恕先生为典型代表的。

我们今天通过《康平本》再来解读的时候，对这样的条文就会有一种全新的认识。首先这个条文是降两字格的条文，它与顶格条文和降一字格条文是出自不同作者之手，换一种说法，根本就不是一本书呀！这也能充分地证明《康平本》的重要性，只有读了《康平本》的时候，你才能知道这层含义。

《伤寒论》里不仅仅是这条，大家看看序言里，还有伤寒例里，很多这类的内容。这个条文是比较典型的，它已经明确地说用了“五行”的理论，我们现在就借这条来解释经方理论。通过这条我们明显

可以看出来，这条的作者和另外两类条文的作者，在理论上不是一个体系。这条以五行的理论来诠释医理，在另外两类条文，特别是顶格条文中是绝对没有的，几乎只字未提，一点没有。不仅如此，即使是在辨证理论上，顶格条文也没有以具体的脏腑病变来辨证的真正的相关论述。在一本被后人称作经典之经典的医学专著中，几乎只字未提具体的脏腑、具体的病变，这不是一般的情况，不能等闲视之。它必定是作者有意而为之。

我们通过对条文简单地解读，可以发现条文的作者在理论上与《黄帝内经》是一个理论体系。在《伤寒论》里加入的此类条文，《金匱要略》里更多，它正是这个作者以《内经》的理论来解读经方理论的结果。可是我们应该注意一个问题，《内经》成书比《伤寒论》要早好几百年，这是一个很奇怪的问题。如果有《伤寒论》的时候没有《内经》，后来有了《内经》，再拿着《内经》的理论来解释经方理论，这没有什么。就跟我们现在用西医的医学基础理论来阐释中医的，不是大有人在嘛。但是，《黄帝内经》却比经方理论要早。这说明它们压根就不是一个相同的医学体系。实际上，王叔和用《内经》理论来解释经方理论，这是两种不同的医学体系之间的误读，从王叔和就开始了。如果再进一步地分析，既然《内经》理论早于经方理论，而且我们从史料的记载可以明显地看出，以《内经》理论来解释经方理论的并非王叔和一人，绝大多数的注家都走的是同样的路。这说明《内经》理论体系在整个中医的历史上，不仅被大多数的医家所接受，而且始终占有主导地位。用现在的话说，这是中医里真正的主流医学。为什么说是整个中医的历史啊？因为《内经》成书比经方要早嘛。

到今天经方理论依然被奉为是中医经典之一，实际上在于经方的临床疗效的不可超越性。从整体上说，这二百六七十个方子要用得对了，整体疗效非常好；即使是比某个方子，只要是方证相应的情况下，很少再能找到比它疗效更好的这类方剂。但是，由于对经方理论从王

叔和开始走上了一条误读史，一直延续到今天，将近两千年的时间。如果不是有胡希恕经方学术思想的出现，还不知道这种历史要延续多么长的时间呢！结果就是：胡希恕先生恐怕是在中医历史上用经方最好、用经方最纯、用得疗效最好的，就是因为他真正学懂了经方。

事实上，经方医学的核心就是临床经验。所以它必是来源于最原始的人类医学实践，这又是另一个问题了啊。经方医学成书比《内经》要晚，但是它的根源实际上是最早的。就像有些自然界的动物，它自己就会找到一些治病的东西，比如有的鸚鵡吃土来解毒，有的猴子吃木炭来解毒，有的大猩猩可以啃一种特殊的树皮来治疗肺炎。实际上，人类的医学起初也是这样发展起来的。现在不需要用什么特别的史料来证明，大家想一想就行。当初治病，肯定对病因毫无了解，对具体的疾病分类也非常之粗浅，治的就是症状。比如吃这类东西可以治头疼，吃那类东西可以治呕吐，后来慢慢地、逐渐地加深理解、不断总结，就出现了各种的复方。随着对这种原始医学的不断地、深入地研究、总结、归纳，形成了一种以患者患病以后的症状反应为依据，来寻找治疗疾病方法的一种医学。这是经方从原始发展的大概路线。

但是在这个过程中，主流医学随着对人体和疾病地认识，不断加深，就逐渐地形成了以研究病因、具体病变位置和病变性质为主要目的，并且以此来寻找治疗方法的一种医学。它的基本思路与现代医学实际上是一样的。它和现代医学的区别，在于传统医学没有现代医学的科技手段，它看不到微观，所以显得传统医学就比较宏观一些。但是大致理论要点不外乎都是这样：一个是什么样的原因，比如中医理论叫“风寒暑湿燥火”，西医找到的原因是病毒、细菌等等吧。那么，这些原因造成人体的器官、脏腑、或生理系统等等，发生了什么性质的病变，中医里叫做寒热虚实，西医里叫做炎症或者肿瘤等等的。最后在这个基础上要找到用什么样的药，中医就讲究何药入何经，就是药物归经的问题了，不管它有没有这个规律存在，一厢情愿地搞了这

么一套；西医搞得就是什么药杀何毒杀何菌，就是这么啊！这类的医学，虽然它研究的对象非常客观和具体，但是最终得出来的结论常常与临床无法接轨。凡是学中医的都知道这种情况，比如一个人吐的哗哗的，到医院里花了一千七百多块钱，从头查到尾，最终一点病都没有，那这先进技术不无用了嘛！常常有时候得出这样的结论。

还有一个非常典型的例子：在中央十套节目里播的，说孕妇在三个月的时候，是胎儿大脑发育比较重要的一个时期，这个时期如果孕妇有足够的 α 亚麻酸摄入的话，对婴儿的大脑发育非常得有利，生的孩子会更聪明一些。到最后研究的结果看起来非常得好，他说 α 亚麻酸人体自身不能合成，然后必须通过摄入食物获取，食物含这个最多的是核桃。那么得吃多少核桃，才能达到婴儿智力发育所需要的量呢？一天要吃 17 斤核桃。大家看，最后的结论跟临床就没法接轨了。我们不仅要问了，研究这个问题的专家，你母亲生你的时候每天吃了 17 斤核桃吗？我们后边还会就一些临床东西做比较。

我们可以把主流医学，看成那个时候的现代医学。随着现代医学的发展，有了新的东西谁不接受吗？也会接受的。但是通过临床实践发现那些东西不行。后来，只能又反过来重新坚持和发展了人类医学的最原始治疗原则。虽然看起来是最原始的，实际上是最先进的。就是通过人体的症状，来研究治疗人体疾病的通治方法。但经方又与原始医学不同，它是在原始医学的基础上，通过对方证进行系统地归纳和研究，逐渐地形成了一整套完整的医学体系，而且应用于临床有稳定和卓著的疗效。咱们学经方的人都深有体会，并且还有很高的重复性，只要是方证相应，理论上可以说是百分之百有效。说到这里，我们有理由相信：经方医学是一个独立于传统医学和现代医学之外的独立医学体系。

我们再看看临床实践中，经方医学和其它医学的一些区别：比如有两个病人，都因为有“寒热往来，胸胁苦满，默默不欲饮食”来就

诊。现代医学认为只有这些症状不行，得找到到底是什么东西病了，它可能通过现代化的医学手段，最终确定了这两个病人一个是胆囊炎，一个是心肌炎，或者一个是肝炎，一个是肾炎。它检查的这些都没有错，都是事实。但是，它的医学体系要遵守治疗这种病的各自规定，按照它各自的规定，用药也不一样，治疗方法也不一样。最终的结果不单单是治愈率有限，而且治疗的过程中还常常对人体产生严重的副作用。看看最近的报道，美国现在这次流感是 H3N2 病毒，比 H1N1 病毒要厉害，现在也有死人的，症状也比较严重。但是在报道的时候，说对这类感冒（实际上对所有的感冒现代医学都是这样）真正有效的办法是打流感疫苗，但是疫苗的有效率是 60%，现在说得很明确嘛。那么这就可以得出两个结论：第一，对于感冒西医没有任何的治疗方法，它自己就承认嘛，有效的只有疫苗，其它的都是辅助，都是缓解感冒症状，实际上不治感冒。即使它有效的治疗方法，有效率也仅仅是在 60%。这个数字跟经方的疗效相比是非常低的。就是这么低的有效率也只是预防，不是治好的感冒。造疫苗是可控制性的先让你感冒的，刺激人体自身产生抗体，用这样的方式减少得感冒的几率，这还是科学发展的一个成就。

而传统医学对这两种病，它得通过四诊和辨证，最终要辨得或者是心阴虚，或是何脏何腑发生虚实这类的变化。最后在这个辨证的基础上，它要用相应的归经药物来组成不同的方剂予以治疗。大家都知道，中医整体疗效不好，疗效非常低，这就是真正的原因。

经方医学与传统医学是两回事。经方医学是辨准了病理，辨准了方证之后，就那一个方子可以治，或者需要合方就合方得了。传统医学中也有一些疗效比较好的，但那些往往是对医理感悟比较深、比较透的人，如果没有这种天赋的人，疗效就很低了。比如陕西的李翰卿老中医，他那套辨证体系，除了有脏腑辨证之外，其他的表、里、半表半里、寒热虚实、水、血、气全都有。而且他自己说：“我擅于辨

夹杂证”。实际上他是从传统医学里面，感悟出了经方的道理，他对经方研究也比较深的，还是借鉴了经方理论。但是如果把他跟胡希恕相比的话，虽然在疗效上没法直接比较，但是在所用方剂上来说，比胡老的经方程度要差远了。像这种治疗方法最终就是时效时不效。

像这样的病人用经方应该怎么治？经方医学认为这两个病人，整体上都处在阳性的半表半里的虚热证状态，同时合并有里虚证，就是属于这种病理状态。它就是具体表现为小柴胡汤治疗范畴的这种病。虽然各自所患的具体疾病完全不同，性质、部位都不同，但是治疗都可以用小柴胡汤迅速治愈。这就是经方医学和其他医学在本质上的区别。像这种情况，其他任何医学体系的人都感觉不可思议，他理解不了，两种完全不同的病，怎么可能用一个方子来治？所以，用脏腑辨证的人对小柴胡汤的解释是清肝胆之热的，如果遇到肾炎又有小柴胡汤证，他万万想不到用小柴胡汤，最终疗效就这样擦肩而过了。

但是，也不是说除了经方医学，其他医学都是错误的，或者是它的学术体系一无是处。现代医学对于基础医学，或医学的基础和疾病的微观研究做出了伟大的成就。比如人体是由细胞组成的，没有显微镜哪能知道啊！而且传统医学在对整体认识疾病上，也做了一些有益地研究。但是它们都有一个共同的特点：它们的临床疗效是随着研究得不断深入、不断变化而变化的。从理论上说，只有研究到了最后的成熟阶段，治疗才可能趋于理想，但实践证明人体离这个目标还非常遥远。二十年前某些常用的药物，比如链霉素，在当时是非常好的药，现在就禁用了。为什么？实际上就等于说落后了，有疗效，但毒副作用太大，比它先进的药更安全一些。如果再往后推 20 年，现在用的药有相当一部分也用被禁用、被替代，换句话说，现在用的药就成了我们以后要防范的某种毒。但是没有办法，在研究出新药之前，还必须得用这个。

可是经方医学完全不同。它是先有了经历数千年的无数临床案

例，经过无数次的筛选，而形成的一套成熟完备的治疗方剂、应用指征和理论。然后在这个基础上，总结出一套规律性的东西，这发展成一门很成熟的医学，关键的问题在能不能正确理解它。现在在座的有些同学，开始在临床中就用我们学习的病理辨证体系去辨证，就觉得这样辨更清晰、更简单，实际上就是这样，没有什么神秘的。关键问题是你以前了解的那些东西，不是真正经方里面的东西。

通过上边这分析，我们应该知道如何对待这类的条文，是我们学好经方的关键问题之一，这是很重要的问题。许多人在学习经方的路上，就是因为这些条文的误导走偏了方向。这是一个带有方向性的问题！

本太阳、初得病时、发其汗、汗先出不彻、因转属阳明也、（185）

伤寒、发热无汗、呕不能食、而反汗出濇濇然者、是转属阳明也、（185）

胡希恕：本太阳病，初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明也。伤寒发热无汗，呕不能食，而反汗出濇然者，是转属阳明也。那么头一个，他说太阳病。那么太阳病依法当发汗呐，那么发汗而病不除，这个“不彻”不是不彻底，啊，就是病不去。这个真正的这个重病啊，不只伤寒如此，就现在这个流感也这样子。那么开始表证是要发汗。发汗，真正的这种重的…这种流感呐，也不是一汗能愈的。那么汗后他也可以传变为少阳和阳明的。他这个就说的这个意思。大病的时候就是你治疗得正确，啊，也只能啊，在这个表证的时候，太阳病这个阶段，啊，使着它好转，啊，减轻，就是除其这个凶势。但是这个病他还是要传变的，不能就好。这个伤寒一般好啊，都全在这

个少阳病的末期，阳明病的初期的时候，大概都在这个时候好的多，啊。就是白虎汤啊，嗯，或者是调谓承气汤这个阶段。他这一个就说的是这个，他说本来是太阳病，依法当发汗，那么发汗之后病不彻而转属阳明，有这个事情，啊。他第二个，他说“伤寒发热无汗，呕不能食”，呕不能食者，啊，这由太阳传到少阳了。那么由少阳而“反汗出濇濇然者”，这个“濇濇然”呐，就是连绵不断的意思，就是不断出微汗的意思，啊。那么它又转属阳明了。这就是他解释头前儿这个太…啊，太阳阳明，少阳阳明的这么个来头。有太阳病，啊，虽然依法发汗，他也有不好的；在少阳病也如此，啊。他说本来是太阳伤寒，他没有汗嘛，他转属少阳他呕逆，啊，所以少阳病他发热而呕，这也是柴胡证，呕而不能食。那么但少阳病他也不出汗呐，而反汗出濇濇然者，它又转属阳明了，阳明病法多汗，后头有的，啊。头前咱们讲那个外证不也是么“身热汗自出”啊。这就头前儿这两段呐，这应该是两段，他这个书搁一段了。成无己那本就是两段，这就说，由太阳病转属阳明，由少阳病也转属阳明的，这么两段。他，因在咱们在太阳病都讲了，在这个阳明病，这一个他都说得非常的略，啊。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边，是降一字格条文，是另一个作者作的。

《宋本》里边这是同一段内容，但是在《康平本》里边是两个自然段，我们下边把它分开解读一下：

第一段是这个条文作者，对发生阳明病的一种病因所作的论述。大致意思就是说：本来是太阳病，太阳病初得的时候，虽然经过发汗治疗，但是因为发汗不得法（这肯定了啊，要是得法，太阳病就好了），或者说方与证有所出入，虽然得汗出，但是没能治愈疾病。“汗出不彻”，不是指的汗出的量或者说出的程度不彻底，不是那个意思，是说虽然得了汗出，但是病没有治好，反而津液损失过重，有可能使这个疾病进一步发展为阳明病，这么个意思。

这一类的情况，顶格条文在太阳篇里有多处论述。因为经方理论重证不重病因，他那种论述大部分都是隐藏在方证条文当中。像这样的条文专门加以论述，可以帮助读者比较全面地理解经方理论。但是我们需要明确的是，这只是发生阳明病的原因之一，而不是唯一的途径。

第二段，“伤寒发热无汗，呕不能食，而反汗出濇濇然者，是转属阳明也”，论述了一种由表证发展为半表半里证，又进一步发展为里证的这么一个过程。揭示了人体阳性疾病在不同类型之间的发展变化的一种常见的形式，有一定的规律性。

“伤寒发热无汗”，这是比较典型的阳性表实证的症状反应；“呕不能食”，这在少阳病里边，是一个比较典型的症状反应（在经方理论里边，常用“呕”来代表少阳病）；“而反汗出濇濇然者”，就是说无论是少阳病也好，或者说太阳病也好，都不应该有这种症状反应（这儿说得比较客观啊，这个汗连续不断地出），所以这儿用了一个“反”字，示意这个疾病发生了质的变化。这儿的汗出，是指的典型的阳性里热证的汗出。应该跟桂枝加附子汤“漏汗”的那个症状，有质的区别。

这个条文可以看作是，以阳性疾病当中，三种不同类型的典型症状反应为例子，来阐述疾病常见的发展变化规律。因为这一篇是论述阳明病的，所以这个条文在这就是主要阐明发生阳明病的路径之一，应该说这是主要的论述目的。

伤寒三日、阳明脉大、（186）

胡希恕：“伤寒三日，阳明脉大。”就是太阳伤寒转属阳明，啊。那么那到这个三天的时候，也看他…如果转属阳明了，其脉必大，阳明脉大嘛，他内热盛嘛。这一个我们回头你想一想，咱们讲白虎汤那

这个时候，“脉洪大者”，啊，他绝不是桂枝汤证啊，他还是…他这个脉他弄串了。这个桂枝汤证只是脉浮，脉浮缓。所以这个脉大，洪大，啊，他里，内热盛。那么伤寒三日啊，也每每的，这个病要是…这根据太阳头一篇，伤…啊，太阳病二三日，少阳阳明证不见者，为不传也。它有的时候在这个三天的时候，啊，有其玄机的，这个证候没有，但是脉在这个时候大了，那是肯定他要传阳明。他也借机会在这儿，把这个阳明这个，啊，这个热盛的这个脉呀，在这儿特别提一提，头前净说些证了。

李冠杰：这个条文是降两字格排版的条文。

咱们也解读下：

关于阳明病的脉象，在太阳篇的顶格条文有多处论述：第 26 条白虎加人参汤证，有脉洪大；第 176 条白虎汤证，有脉浮滑。但是，实际上临床当中，阳明病并不是只有这么一种脉象。所以这个“脉大”，我们可以视为一种比较典型的常见的阳明病的脉象。

而对这个条文理解成什么呀？理解成：当表证经过数日不愈，如果出现了脉洪大这一类脉象的话，则可能是发展为阳明病了，你要细审有没有其他的阳明病的症状反应存在。

咱们上一次学习完了以后，我当天晚上就发烧、阵寒，到了下半夜呢，出了一点点汗，出完这次汗，感觉轻松了一点，过了一会儿马上就又出汗，我想这不是麻杏石甘汤证嘛。第二天的晚上就吃麻杏石甘汤，白天基本上一天都是低热，也挺难受的。因为白天上班不想让出汗，不想吃发汗药。晚上回来，我折腾了一晚上，服了三次药。第一次药，是麻杏石甘汤，喝了以后，一会儿就迷迷糊糊地睡着了。醒了以后，身上微微出了点汗，鼻塞，头疼那种表证，基本上就缓解了很多很多了。但是，过了一会儿，那个轻松的劲过去以后啊，又开始有点低热，头有点沉，又开始难受了。有一阵一阵的冷，我就吃了麻杏石甘汤二小柴胡汤一，这一次又出了一些汗，而且汗呢，比上一次

稍多一点。到了天快亮的时候，又吃了一点小柴胡汤合栀子豉汤，吃了以后挺舒服，然后就起床，吃饭，去上班。截止到这个时候，感冒症状基本上结束了。按照我们经方的说法，表证就没有了。剩下的就是里热，就是阳明病。

整个这一白天，逐渐得热，热到什么程度呢？就是鼻孔里面呼出的气，包括二便全是热的，都有灼热感，就热得这么厉害，我就开始吃白虎汤。到了晚上，考虑到前边出汗出得多了一点，考虑有点虚，晚上吃一点竹叶石膏汤。晚上又出了两次汗，而且都是大汗，比前边吃发汗的药，出汗出多了，那个量大。这时没有别的了，就是热，里热太重了。我这几天，基本上拿白虎汤当水喝，一天比一天轻。但是，去阳明病里热的这个过程。跟解表不一样，吃下药之后，出点汗就好了，不是，没有这么快，特别是热重的时候。现在偶尔还会咳嗽一两声，有时候这个热往上蒸得厉害。

整个过程里边，我也吃了好几个方子。我今天下午吃的是麦门冬汤，就是嘴唇也干了，口里面也粘了，吃了以后胃里边很舒服，然后饿的不得了。这一周里边，一次药没有吃错，但是这个病基本上跟我闹腾了一周。我前三天的时间体重下降了 3.5 公斤。我也在算这个体重下降，也不全是出汗。那么体重耗在哪啦？就是因为人体过度亢奋，鼻孔里边出的气是热的，二便是热的，这么大的热，这些热哪来的？都得有能量。而且这个过程当中，我食量一点没减，体重下降了这么多。当然这种急速体重下降，很快就回来了，后边两三天的恢复，大约体重又增加回 4、5 斤的样子吧。整个这个过程，我就感觉到了，为什么甲流严重？就热得厉害。而且这种病，你一旦用错了药，比如一开始用了桂枝汤，或者麻黄汤，非坏事儿不可，一定使病情重的不得了。

伤寒脉浮而缓、手足自温者、是为系在太阴、太阴者、身当发黄、若小便自利者、不能发黄、至七八日、大便难者①、为阳明病也、（187）

注“大便难者”《宋本》作“大便硬者”。

胡希恕：“伤寒脉浮而缓，手足自温者，是为系在太阴。太阴者，身当发黄；若小便自利者，不能发黄。至七八日大便硬者，为阳明病也。”伤寒脉应该浮紧呐，啊。伤寒呐，他是表实。他这个精气…精气充斥于体表，所以脉浮紧。他这个…他这个脉，啊，里头充…充血，一摸着他紧。那么现在这个脉呢？浮缓，浮而缓，弱。这就是…啊，精气不足于外呀。这说明什么问题呢？当然这里头有留湿留饮的情况。我们方才不讲嘛，啊，脾为胃行湿，他这个湿行，啊，输送到表来，这个脉络他就紧；那么如果这一种，由于胃虚不汗出的一个脉了……（音频缺如）

伤寒脉应浮紧，是表实，是津液充斥于体表所以脉浮紧，脉里面充血，一摸脉紧，现在脉浮缓，弱，这个是津气不独于外，这说明里面有留湿留饮的情况，方才不讲脾为胃行湿，湿输送到表，脉络就紧，如果由于胃虚不汗出的脉就缓。

太阳病当发热，今止于手足自温，则热已内陷，当是病传于里而成太阳太阴的并病，故谓为系在太阴。太阳内陷的热合太阴在里的湿而成瘀热，则身当发黄。若小便自利，则湿从下越，便不能发黄。至七八日大便硬者，又成胃家内实之候，前之小便自利，亦正是热极于里，津液流离所致，故不得以系在太阴视之，其原来即为转属阳明病。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。

《康平本》里这个“大便难者”，在《宋本》里是“大便硬者”，没有质的区别。

下边解读一下：

解读这条的关键在于如何理解“系在太阴”。在前边的学习中，

我们对《康平本》不同排版格式的作者也做过讨论。根据《康平本》里条文的分类情况，我们已经知道这三个作者他们之间的差异，也做过了一点探讨。那么理解条文里的“系在太阴”，也离不开这个基本的问题。这个条文的作者实际上仍是以《内经》的理论来误解经方理论，或者也没有必要说是误解，他这是从自己的观点出发，用《内经》的理论来解释经方理论。

这儿的“太阴”指的是什么呀？恐怕这种解释为数不多，特别是在我们这个圈子里，你可能没听到像我这样的解释。大家看看对不对，可以共同来探讨。条文里的“太阴”，它实际上就是指的人体经络的足太阴脾经，“系在太阴”的本意是说问题出在脾脏上，这是条文作者的本意。关于这点，大家去看看《金匱要略》“黄疸病”篇，第一条里有“脾色必黄”的论述，该条和咱们现在学习的“系在太阴”可以互相佐证。《金匱要略》里的条文，可以佐证这条的“太阴”是脾和其经络。而这条又反过来可以佐证《金匱要略》“黄疸”篇里的第一个条文，它的作者和这个作者是同一个人。大家可以翻翻看一看，因为说的都是发黄的问题，而且在《金匱要略》里说得更明确，直接就是“脾色发黄”。作为这一点，其实解释不解释都一样，大家都知道。“脾色必黄”是医经派的理论，就是《内经》的理论，它认为脾属土，土色是黄的，所以说人体出现发黄的疾病，一定是跟脾有关的，这就是从那个体系过来的。

这条如果这么理解“系在太阴”，整个条文前后通顺，而且非常容易理解。就不用去拐任何的弯，都是直接的，只要把意思前后贯通起来，它都是一致的，而且非常畅通。

“伤寒，脉浮而缓”。由于体液充于体表，无汗的这种伤寒常常表现为脉浮紧，这个在学太阳病的时候，机理已经说得很透彻了。但是，在这个条文里边，却把它论述成什么啊？它表现为有伤寒病的典型症状反应，但是脉象却表现为浮缓的脉，这里边肯定是有原因的。

从条文后面的内容看，应该指的是有表证又有里饮。它本来应该是洪大或者浮紧的脉，但是由于大量的体液滞留于体内，所以说体表的体液不像正常的表证或者里热证那么充盈。所以它反倒是像桂枝汤证中风证那样，它有一些体液的损失，它紧不起来。这儿是体液供应不足，就是从体内蒸出来的体液没有那么多，它也会这样子。

“手足自温者”，是有里热证的反应。“手足自温”与里虚寒证的“手足厥逆”应该是对应的。

“是为系在太阴”，作者的原意是想说上面的情况属于湿热困于脾的反应。用经方的理论来解释，它实际上就是：有里热证的同时又存在里饮证。

“太阴者，身当发黄”，这就跟《金匱要略》里的“脾色必黄”对应起来了，这是一脉相承的，是一个理论体系。它原意就是说在脾有湿热的情况下，常会出现黄疸病。

接下来“若小便自利者，不能发黄”，是说里热明显，里饮不重的话，它就形不成黄疸病。“小便自利”说明体液代谢还基本正常。

“至七八日，大便难者，为阳明病也”。如果在既有里热又有小便自利的情况下，体液代谢基本正常，在这种情况下如果迁延的时日多了，它就会导致大便秘结，这个机理就是由于长时间的里热，使津液虚损，就会造成纯粹的阳明病。

本条论述的是一种里有热证同时又有停饮证的情况下，一旦出现了这样的病理常会导致黄疸病的发作。但是如果停饮证不重，经过一段时间以后，就有可能阳明里热证进一步发展为里实热证。

实际上，顶格条文在太阳篇里都有所论述，其他的条文里也有，像第 236 条里茵陈蒿汤方，茵陈蒿汤方证对黄疸的论述也比较清晰。但不同的是现在学习的这条，它用了脏腑经络理论来误读经方理论，反而使得本来非常明显的意思，变得难以理解。“系在太阴”的解释，历代不同的注家各有各的解释，都解释得非常曲折婉转，实际上它本

身的意思没那么复杂，它就想说这么一个非常简单的意思。

伤寒转系阳明者、其人濇然、微汗出也、（188）

胡希恕：伤寒本无汗，但如转属阳明病，其人必濇然微汗出也。太阳伤寒转属阳明之始，于脉当大，于证当濇然微汗出，此示人以见微知著之法。

李冠杰：在《康平本》里边，这也是一个降二字格的一个条文。

“伤寒”本来为阳性表实证，它的症状反应以没有汗为常。但是一旦发展为阳明病，就有可能表现为有汗出，反倒成为有汗出了。阳明病汗出的特点是呈现一种连绵不断地那个样子。这个“伤寒”，不仅仅是发生阳明病之前的病理状态，同时还有患者仍然保持着伤寒病的某些特征性的症状反应，有这方面的意思。

关于这一点，顶格排版的条文也有多处论述，太阳篇就有好多条文，说的不是伤寒，但冠以伤寒。冠以伤寒实际上不是平白无故地把这个伤寒当做一个疾病，这么一个抽象词来用的，它有它自己的意思。后世读者往往在这一点上，不能正确地理解，看到麻黄汤证他用伤寒，甚至不是麻黄汤证，包括白虎汤证他也冠以伤寒，最后闹出一个广义的伤寒和狭义的伤寒。本来论述的不是伤寒，但冠以伤寒，也不能说和伤寒无关，无关的话，这么经典的经文不可能出这样低级的错误。所以到最后也可以说是牵强附会，弄出一个广义伤寒，只对于那种单纯地论述阳性表实证的那一类的条文，才把它界定为狭义伤寒。

其实他们所谓的广义伤寒都有用处的，有的是指这个病是由伤寒病发展而来的，那么伤寒在这儿就作为病因；有的不是由伤寒病发展而来，而是它现在还表现为有伤寒病的某些典型的症状反应。如果我们要很好地去理解这一点，这里等于借助于这个条文，来进一步地去理解经方理论了。尽管这作者跟经方理论不是一个体系，但是他的条

文能把问题说了，咱们就借助这个问题，再深入地讨论一下。

要想对这个问题做一个深入地理解，我们有必要结合临床实践，今天咱们就有一个很现成的，我自己就是。咱们拿一个具体的条文说，顶格条文第 176 条“伤寒脉浮滑，白虎汤主之”。它论述的是阳性表实证发展为阳明病的另一种形式，现在这个条文跟它有所对应，由无汗转变为“濈然汗出”；但是那个白虎汤证的条文它由脉浮紧（伤寒不是脉浮紧嘛）转成了脉浮滑，跟这个条文就有一定的对应关系。既然已经发展为阳明病了，像顶格这样的条文，而且文字那么简，他为什么还要冠以伤寒呢？我们先想一想临床，我们先用抽象的数字来说问题。

在实际临床应用当中，白虎汤所治疗的疾病里边，包括流感、肺炎（包括大叶性肺炎这样的疾病）。大家想想：这样的疾病会有什么样的症状反应？白虎汤是什么症状反应？如果它表现为流感的话，恐怕是稍微有一点经方理论基础的人都会说，如果有白虎汤证的话，肯定会表现为不恶寒，这是最根本的一个区别点。事实上，临床当中远没有这么简单。假设这么简单的话，历史上的温病派就根本不可能出现。就是因为都呆板地去套这个条文，一看他也怕冷啊、也发烧、还流鼻涕、而且还有一点汗，这不是桂枝汤证吗？你就让他喝桂枝汤吧。只要有里热，喝了桂枝汤，病很快就发展得很厉害，特别是像现在甲流那样。我今天为什么非得在这儿，把成了定论的一个事，非得要把它说得让你觉得半信半疑？因为我这次就感觉非常明显。我有明显得怕冷，有明显的恶寒，但是它热得厉害啊。为什么不会吃错药啊？在自己身上感觉太明显了。它热啊，那一派的热象，到了第三天的时候，舌苔都成了黑苔了，吐出来的口水就跟稀释了的酱油一样，你想这得有多大热啊。就是这么大的热，还老是觉得怕冷呢！而且前边已经把表解了，表证的反应几乎都没有了，像鼻塞流涕这类的基本上都没了。但是我这个怕冷啊，我自己也知道，因为它前面接二连三地出汗。阳

明病出汗不是正常现象吗？这出汗出得多了以后，表这一层相对来说就比较弱了，再加上体温有点高，就是感觉恶寒。

虽然说它跟表证的、半表半里证的恶寒不太一样，没有那么重，但也是老想穿衣服。大家再想想，如果有恶寒存在，再没有汗，说它是伤寒，这时候再回过头来想想这条文“伤寒脉浮滑、白虎汤主之”。你越体会，别看就这么几个字，说得极准确。

就说你面前有一个人，他到处、各个症状都是伤寒病的症状，但是他脉显示为浮滑的脉。经方特别是顶格条文，它常常用方剂来说话，又给你补充了一大块儿。它肯定是除了脉浮滑以外，还有很多的热象，鼻孔里出的气有灼热感了、舌苔黄了、舌质红了这些都不算吗？都可以算啊。大家想想，一个方面有这么严重的热证，另一个方面，它确确实实表现出来的好多症状，跟太阳表实证就非常相似，怎么办呢？如果让你去写一条论文去论述这种情况的话，咱们现在可能会用一大篇，就像我现在唠叨了半天，就是想说明它这个“伤寒脉浮滑”，就是有一大堆的典型的伤寒病的症状反应，但是你看脉象，是一个浮滑的脉，典型的热证啊，你可以再去找有没有其他的热证。

如果表现了一派的阳明里热的症状，又有一些太阳表实证的症状，大家可能会想到，这不是大青龙汤证吗？为什么要用白虎汤来治啊？他用白虎汤本身就说明问题了，跟大青龙汤证还是有明显区别的，比如恶寒的程度上、身重等很多地方，应该说是区别的。

如果我们能这么理解的话，结合临床再来理解条文，里边很多这样的条文，都可以给我们揭示一个问题：人体患病相当得复杂，不能给它简单化。不能把它一厢情愿地想到，你要是阳明病就必然会出现“不恶寒但恶热、汗出濇濇然”，它要都这样，多好啊！实际临床当中不完全是这样。如果遇到不是这样的时候，就不会治了！为什么用桂枝汤下去不行啊？有点汗我用桂枝汤，如果没有汗，我改用麻黄汤，用了之后症状反而更重了。上次我和大家举这个例子，为什么病人吃

了麻黄汤不行啊，发了汗病不好，然后又要他喝桂枝汤，病又不好。最后喝的什么？那方剂和白虎汤不是差不多嘛。为什么会出现这种情况？大家想想那些时方的医生、温病的医生，历代为什么会出现各种派别？就是一开始用经方的方子，辨证不对，把热证当成纯表证治了，把里热给忽视了。

所以在临床当中，一旦发现表证，一定要看看有没有里热，有没有水证，这些都很重要。一旦有了水证，麻黄汤、桂枝汤就不能用了；一旦有了里热，麻黄汤、桂枝汤也不能用了，所以说辨证是很重要的。

还要补充一句，条文里面说过，有阳明病同时又有表证的，先解表，后攻里，那是指的泻下的方法，而不是指的里热证；另外一个，发现有表证，一定要看看有没有里热，一旦有了里热，这个表证的性质有时会发生变化。如果是表证，不是特别典型，单独治里热都行，条文里说了：“伤寒，脉浮滑，用白虎汤”嘛。大家慢慢地去体悟，这个不好用一句话把它界定得非常死，因为人患病确实就是非常复杂。后面也有，阳明病既有有汗的，也有无汗的；既有小便正常的，也有小便不正常的；有大便硬的，也有大便不硬的。人患病之后本身就那么复杂，这是事实。所以不要一厢情愿的或是愿意让他：凡是阳明病都那样多好，实际上不是的。到最后，主观上看问题，那就得出问题。

阳明中风、口苦咽干、腹满微喘、发热恶寒、脉浮而紧、若下之、则腹满小便难也、（189）

胡希恕：…那么在这一个时候“发热恶寒脉浮而紧”，这是太阳的脉嘛，啊，太阳汗不出汗的脉嘛，这不太阳伤寒的脉嘛。那么这个时候，虽然病发于里，他里不会实的，而且应该先解表，这是定法，咱们头前讲过。这个就是大青龙汤证。大青龙汤证啊，只是“不汗出

而烦躁”，这一个当然也不汗出啊，也得有烦躁，但是又加上“口苦咽干，腹满微喘”。他这个热比那一个盛，啊，这个证形啊，偏于阳明。“腹满”，其实这个腹满呐，还是不是实。“微喘”，这个我们讲的阳明病啊，由于这个腹…啊，这个病实于里向上压迫，也能发生喘，这是一个，啊，必须用泻药才能治这个喘。那么这一个喘呢，还是麻黄证，啊。这一个腹满，啊，还是，啊，咱们说这个气滞不畅了，啊，这么一种的自己感觉满，其实不是有实物东西那个满。怎么见得呢？看看后头。“若下之”，假设这个时候，啊，我们要用的话还吃大青龙汤。要不然的话，误于里实而下之，则腹满小便难也，原来就腹满，这一回…这一回真腹满了，这个腹满是虚满了，啊。由于胃虚水谷不别，所以小便也难，啊，都从大便走了，后头有的，啊。那么这也就是说是我们这一个，啊，后…啊，古人也说是啊，“下不厌迟”啊。它本来是大青龙汤证，就是头前儿说太阳中风，啊，脉浮紧，啊，发热恶寒，身疼痛，啊，不汗出而烦躁，就是那一节儿。这一个呢，它有“口苦咽干”呐，啊，他这个热较比更盛了，更盛但是，还是，从底下这个发热恶寒脉浮而紧，这还是个表实啊，还得先解表，然后再说了。虽然并发，啊，阳明，但是里只有热而不实。不实，你要…要泻，非虚其这个…啊，虚其胃，他反到胀满了。由于胃虚，啊，水谷不别，小便难了。他都从大便走了。

李冠杰：这个条文也是降两字格的条文。

这个条文可以做两种理解：一种是三阳合病，另一种是二阳合病，也就是太阳阳明合病。

这个“阳明中风”，学习《伤寒论》出现这样的词汇，这是第一次。第190条中：阳明病能食的，属于“阳明中风”。这是降一字格条文作者提出的这样的问题，降两字格条文的作者又把它升华成另一种疾病，就是这么来的。

“口苦咽干”，是理解这个条文合病多少的一个关键症状，如果

看作是少阳病病证的简述，那么这个条文论述的就是三阳合病。也有人把“口苦咽干”解释成：因为里热太盛，上蒸于口腔，也能造成“口苦咽干”。如果这样理解的话，就是二阳合病。这是三阳合病，还是二阳合病都不重要，重要的是：它不是一个单纯的阳明病。所以，都不能贸然用“下”的方法治疗。

就因为有这个论述，有人就说：阳明病有口苦。第 189 条论述的阳明病就有“口苦咽干”。如果把这个口苦咽干理解成少阳病的症状反应的话，阳明病里面就不应该有。而且从临床当中，也很少这样的症状。因为单纯的里热，咽干倒很容易出现，有口苦这种情况，我没有遇到过，这种情况是比较少的。

“腹满微喘”，这是阳明里热证的症状反应。从症状上看，认为有里实证的存在也可以，没有太大的问题。

“发热恶寒，脉浮而紧”，这是典型的阳性表实证的症状反应。

这个条文论述的：在阳明病的同时，还有一种或是两种其他类型的疾病存在的情况。按照经方的治疗原则，太阳和阳明病合病的话，阳明病是需要下的，那得先在解表之后才能攻里。所以这个地方，用下法肯定是不合法的。如果是三阳合病，必须取少阳施治，以少阳为中心，开展施治。所以下法根本就没有应用的机会了。

所以论述了：“若下之则腹满小便难也”。其实真要是误下了以后，所出现的后果，不一定仅仅表现为这个样子，可能还会复杂一些。

这个条文就等于再次强调了经方理论的治疗原则。

阳明病、若能食、名中风、不能食、名中寒、（190）

胡希恕：“阳明病，若能食，名中风；不能食，名中寒。”这个能食是有热了，啊，咱们说热化食嘛。这个阳明病，这个人如果能吃，这是里头多热，啊。古人以风为阳邪呀，所以说中风。“不能食”，

胃虚停水，啊，他就不能吃东西，水性寒呐，啊，他所以名叫名中寒。这是以这个能食与否而分…分辨这个阳明病为中寒、为中…为中风、为中寒的这么两个病的……啊，区分。这个没什么意义的，这个我们后头啊，这个治疗就看出来了。这个不能食也不要把它就看…看成里必有停饮。在阳明病有两个阶段，一个阶段，开始能吃，啊，这说明里头有热；可是呢，大便不通，他里头真正实到一个相当程度，他也不能吃了，那一个不能吃说明里头有燥屎了，啊，他老不拉…不拉屎，他吃什么？所以这个，只是就“不能食”来分…分辨，啊，为风热，啊，为寒…，啊，为寒湿等等的这个也有，啊，也有不成立的时候。但是这一个呢，他随便分这么两个病形，这就由开始上说的，啊。这个病的这个过程啊，在开始的时候，以能食、不能食，而来区分阳明病为这么两种的证，啊。一个叫做“中寒”，能食者“中风”不能食者“中寒”。

李冠杰：这个条文呢是降两字格的条文。

解读一下：

这个条文，对于理解经方理论，没有多少实际意义。阳明病本来就是机能偏于亢奋的阳性里热证。在通常情况下，从食欲这个角度看，他应该表现为食欲比较亢奋，这样的表现比较多，这是阳明病的病理特征所决定的。但是对于这一类的情况，降两字格条文的作者又特别给这种能吃的阳明病，起了“阳明中风”之类的这种病名，这本身就是多余的。因为在经方里面，有这个概念是这么个事儿，没有这概念也是这么个事儿，对治疗、对理论都没有什么影响。

“不能食，名中寒”，应该是阳明病同时又伴有停饮证。一般古人哪，把里寒跟里饮往往都不分的。一旦有了这种情况，就常常表现为食欲不振。这个“阳明中寒”的命名，跟那个中风一样，没什么用处。那么他怎么来的呢？下边这个条文，你一看就明白了。

阳明病、若中寒者、不能食、小便不利、手足濇然汗出、

此欲作固瘕·必大便初硬后溏（注）所以然者·以胃中冷·水谷不别故也·（191）

胡希恕：“阳明病，若中寒者，不能食，小便不利，手足濇然汗出，此欲作固瘕，必大便初硬后溏。所以然者，以胃中冷，水谷不别故也。”他说阳明病，啊，“若中寒者”，头前儿不说中寒者不能食嘛，而不能吃东西。“小便不利”，啊，小便不…不利这个水就停在上边儿，所以他不能吃东西。“手足濇然汗出”，这个阳明病法多汗呐。如果手脚也不断出汗，那大便就硬了。这后头专有讲的，啊，大承气汤里就有这个。那么大便硬，可是由于小便不利，他水谷不别。“此欲作固瘕”，这固是坚固了。瘕呢？就是时聚时散者谓之瘕，啊。那么也就指着大便有硬块儿，但是头前儿，后头还是稀的。所以也就指的大便初硬后溏，这个固瘕这个意思。那么为什么呢？以“胃中冷”，胃中冷不是胃寒。他胃中…啊，有冷饮，他小便不利嘛。本来他应该大便干，太便硬，他有了水在里头，所以他才大便初硬后溏，啊，他因为水谷不别呀，这个水也要走大便，啊，那么大便固然干，又加上水呢，他又为固瘕之便了，就是初硬后溏。那么可见呐，头前儿那个名中寒呐，啊，他是停食、停水，他不爱吃东西。

李冠杰：这条在《康平本》里是降一字格排版的条文。

条文里的“若中寒者”。我们先看第 190 条“阳明病，若能食名中风；不能食名中寒”，“若中寒者”指的就是“名为中寒”而言的。阳明病中寒就不能食，然后降两字格条文的作者进一步发挥了一下，把这种“阳明病，不能食为中寒”的情况，给它起个名字叫做“阳明中寒”，实际上一点用都没有。

第 191 条的大致意思是：阳明病本来应该食欲较为亢进为正常，但如果同时存在停饮证，就可能会出现食欲不振的情况；并且还会表现有小便不利、手足濇然汗出、大便初硬后溏这类的症状。

“小便不利”就是体液代谢不良的一个典型症状。

“手足撒然汗出”是里热证的症状反应。

“大便初硬后溏”是条文里论述的一个特征性的症状反应。在实际临床中，这一类的情況也是比较多见的。这个症状反映了人体生理上一种比较特殊的病理状态：一方面体内有热，加速了肠道内水分的代谢，或说加速了肠道内水分的损失，里热常常会致大便干；另一方面，体内同时又存在停饮证，又常常会致大便偏溏；两种情况同时存在，如果是以里饮为主的时候，就形成了一种介乎于两者之间的情况。在消化道内滞留的时间比较长的内容物，水分蒸发得比较多，它就会变硬；而滞留时间比较短的，就是另一种情况了，它就会偏溏，水分就偏多，也就是条文里论述的“大便初硬后溏”。后边还有其他的说法，如“大便初头硬后必溏”都是指的这类的情况，是既有里热又有里饮的情况。在临床当中碰到这类的患者，就按这种病理确定，肯定有这两方面的倾向，一般是不会有错的。

旁注“此欲作固瘕”，在《宋本》里看不出它是一个旁注内容，好多后世注家把“固瘕”理解为条文里的“大便初硬后溏”的病证，认为这就叫做“固瘕”。我们细推敲会感到明显不妥，如果真是这样，论述也没有必要用“欲作固瘕”，它已经形成了，还何必“欲作固瘕”呢？用“此为固瘕”不行吗？这个“固瘕”还有另一种解释，叫“大瘕泻”，这是一种久而不止的溏泻。虽然不是痢疾，但是长期大便偏溏，指的就是这类的疾病。这种解释跟学习的条文里的“固瘕”反倒是比较确切。这个旁注本意就是指这类里有热而且又伴有停饮的情况，容易发生长期大便溏泻的疾病。如果失治，人体状态还不能自然恢复，就可能会陷于这种疾病状态。实际在临床中，大便初硬后溏这种患者见到很多，常常有这样腹泻两三年的，但是真正由这种病发展成为久泻的，不是特别多。出现这种情况的原因常常连患者也说不清，是不是通过这种方式过来的也未必。比如乌梅丸证，常常就伴有久泻，

但乌梅丸证应该是寒热错杂，跟里饮证的关系不是特别密切。

后边这一段附注内容把它称作嵌注：“所以然者，以胃中冷，水谷不别故也”。是对条文所论述的这种情况作的病理解释。“胃中冷”应该就是指停饮而言；后边的“水谷不别”也是做了进一步地解释。“水谷不别”是古人对因停饮证造成大便溏泻的这类情况，在病理角度上做的一种解释。

阳明病、初欲食、小便反不利、大便自调、其人骨节疼、
翕翕如有热状、奄然发狂、□□□□濺然汗出、而解、（注）

汗出而解者·此水不胜谷气·与汗共并·脉紧则愈·（192）

注：《宋本》此条文如下：

阳明病，初欲食，小便反不利，大便自调，其人骨节疼，翕翕如有热状，奄然发狂，濺然汗出而解者，此水不胜谷气，与汗共并，脉紧则愈。

胡希恕：“阳明病初欲食，小便反不利，大便自调，其人骨节疼，翕翕如有热状，奄然发狂，濺然汗出而解者，此水不胜谷气，与汗共并，脉紧则愈。”“初欲食者”，就是开始，啊，由太阳转属阳明，能吃。能吃说明里头有热了。有热者，我们头前儿讲了，小便应该自利呀。“而反不利”，小便反倒不利，啊。“大便自调”，但是大便并不稀，他里头有热的关系，可也不硬，这也是水谷不别造成的。

“其人骨节疼，翕翕如有热状”啊，那么冲这个骨节痛，翕翕有热，这说明他还是一个太阳伤寒，啊，表证还没去呀。这就是由太阳伤寒，初传于里而并发阳明病这个时候，这个人能吃，但是这个小便还不利……（音频缺如）……但他不是整个转成阳明病了，不是那个样子。所以他搁个阳明病这一个…这个冒语，就说明这个胃气强的一种表现，就是能吃。他还在太阳病阶段，太阳病阶段呐，这就说这一个，这个机体对这个疾病，还是要从表解。要表解得怎么样呢？他得加强

精气，是吧？加强精气他就得胃得亢奋嘛。他是这么一种……一种，啊，情况之下，所以这个…啊，达到一个相当程度，啊，他就要发生瞑眩状态，忽然间这个人就发狂，啊，出一身汗，这个病也就都好了。那么这个道理他底下也解释了，此水不胜谷气呀，与汗共并，脉紧则愈。脉紧则愈呀，不是这一个，啊，奄然发狂，啊，这个…这个…这个，啊，汗出而解之后脉紧，不是啊，这一个是其人骨节疼，翕翕如有热状那个时候脉就紧，根本那个脉就紧，那就是太阳伤寒。太阳伤寒呐，哎，这个人呐，就像传里似的，发生阳明病了能吃。这说明他是胃在里头起亢…亢进作用，啊。他是一个所谓胃气强吧？那么虽然小便不利，他不为，啊，不为便溏、腹泻那一种证候，它水谷不别呀。他正是这个，人这个生理机能啊，根据他这一个，啊，还是要由表而解除。那么所以这一个，啊…他里证也好了，他小便不利当然也好了，就是这个水不胜谷气。这个胃气强起来呀，不但表解，啊，而且这个他小便不利内里头停这个水呀，水谷不别呀，也都一起好的。它不胜谷气。那么这个就说明，啊，这个不是真正的阳明病。太阳伤寒，也没真正发生太阳阳明并病，也没有，啊。这就说自愈之状啊。如果病日久，也有发生瞑眩的，这个“奄然发狂”不是个坏现象啊，啊。完了出一身汗，这都是瞑眩状态，这个病要好的时候，啊，常常的发生一种这个，啊，特殊一种反应，这古人叫做瞑眩，这个也是的。所以这个表证时候，这个病就要由表解除疾病。他这个表证始终不衰，脉紧，骨节疼痛，翕翕发热，但是，这个外热不那么甚，所以他搁个翕翕如有热状，啊。不像那个太阳中风那一种热。嗯，这一段他说明，啊，这一个治病不能伤正啊，是吧？这个他自愈呢，也是这个，啊，这个胃气呀，他特别亢奋起来才能好。那么那个阳明病咱们后头要讲，要用泻法了，要用下法了，啊。再不就解热的这一种石膏证，这都与害有，啊…不利。所以我们治这个病啊，也要慎重啊。胃要是不行了，他不但不能去水气，是吧？那么就是我们在太阳病的时候表也

不解，咱们桂枝汤那个主要的他津液虚，他用些…啊，甘温，内里头安中，外可以解表。安中还是养液呀，啊。

李冠杰：这个条文在《宋本》里是这个样子的：“阳明病，初能食，小便反不利，大便自调，其人骨节疼，翕翕如有热状，奄然发狂，濈然汗出而解者，此水不胜谷气，与汗共并，脉紧则愈”。这个条文在《康平本》里边是降一字格的条文。到《宋本》里边把四个缺字符直接删掉了，这个信息就看不出来了。另外把注解文字窜入到正文里边去，为了语言的通顺，做了一些调整，就加了个字。

下边我们解读一下：

这个条文在《康平本》里是一个有残缺的条文。“濈然汗出”之前有四个缺字符，而且这四个字，对于这个条文的整体内容理解，有非常关键的作用。但是我们现在已经无法知道它的具体内容是什么了，所以对这个条文，我们只做字面上一般的解释，不做强解，没必要去做太深入地去探讨。

“阳明病”在这儿，应该是指的有里热证的某些症状反应。“初能食”，就是说刚发病的时候，食欲尚可。“小便反不利”，阳明病本来应该小便自利，或者说频数，那小便不利与阳明病不符，所以出了一个“反不利”，说明还存在其他的原因。

“大便自调”，一般阳明病大多数都是大便偏于干燥，大便反倒是自调，应该说是与前边说的小便不利是相互关联的。因为有停饮的因素存在，虽然有里热，但是大便也没有形成秘结那种情况。

“其人骨节疼，翕翕如有热状”，这是一种里热表闭的这么一种状态。一方面里热将水分迫至于体表；另一方面体表又处于一种闭塞的状态，使水分又不能顺畅地排出去，他就感觉到像罩在那个蒸笼里一样，“翕翕有热状”。这个“翕翕有热状”和后边的“濈然汗出而解”，把这两句话合在一块儿就会发现，它就印证了前边说的是没有汗的，有汗的话还能会出现“濈然汗出而解”吗？因为前边是没汗的，

所以说表闭的情况就是比较明显了。既然是表闭又有里热，会不会是大青龙汤证呢？“翕翕如有热状”，其实这个症状本身就含有与大青龙汤证鉴别的意思，到不了大青龙汤证那种程度。

“奄然发狂”，应该把它理解成：疾病自愈以前，所表现出来的一种瞑眩状态。我们可以把它理解成是一个大青龙汤证但是没有那么重，可是人体的正气又挺强，他可以自行恢复。但是里热也挺重，表实也挺重，在种情况下，人体要想有能力恢复的话，这就跟小柴胡汤误治了以后，会出现战汗，跟那个相似，就是一种瞑眩状态，但这个瞑眩更厉害。人都到了发狂的程度了，这说明人还是有足够的抵抗力的。

“濺然汗出而解”，它的前边有四个缺字符，从现在仅存的文字看，他大致想说的这种情况，就是上边所论述的这种情况，在出现了瞑眩状态之后，可以通过“濺然汗出”的这种形式自行解除。这四个缺字符到底是什么呢？我们已经不知道了，我们就只能这么理解。

后边的注解“汗出而解者，是水不胜谷气，与汗共并，脉紧则愈”，他解释了这类情况，自愈的这个原因。用我们今天的话说，就是人体自身的愈病能力比较强，所以里热和停饮，或者说还存在一定程度的表证，都可以随着汗出而得自解。但是注解最后“脉紧则愈”这个说法，我们可以把它视为不是经方理论的观点，经方理论没有这样的说法。既然“濺然汗出”以后，会不会就呈现紧脉？那也不一定。再说呈现哪一种脉象就能好，这都是说搞脉诊的人，把脉给绝对化了。我们从很多资料里边都可以证明。我们用一句很直接的话来反问就行了，它要是脉紧以后不愈呢？脉紧本身就是一个病脉，它要如果说不愈呢？那你也就不管它了吗？是不是？这本身就不对。

阳明病、欲解时、从申至戌上、（193）

胡希恕：“阳明病欲解时，从申至戌上。”这一个要不得，啊，这一个根据这个，啊，地支，啊，这是一…啊，这是附会这个运气之说。这个头前儿咱们讲太阳病说过了。这是个照例文章。他从太阳病这个六篇，他都是一个，因为这个到戌上，这是一个，啊，土旺之时啊，是吧？这都是这个阴阳运气之说，这个信不信吧，啊，实质上也不是这样子。可也没人考据这个事儿，啊。已至未这是一个，啊，太阳这个阳气正旺之时。那么这一个火能生土了，火之后再申酉到戌，啊，这是一个阳明，这是旺时。所以这一个是好，也在旺时好，这个东西也靠不住的。古人有这么个说法。

李冠杰：这是一个降两字格的条文。

这儿的“申”指的是下午三点到五点，“戌”指的是下午七点到九点。那么“从申至戌上”，指的是下午三点到九点之间这段时间。就是说这是阳明病欲解的时候。

关于这类条文啊，我们在太阳篇里面，学习太阳病欲解时的时候，跟大家已经说得非常详细了。

降两字格排版条文的作者，在六大类疾病里边，都加了一条类似这样的条文。这是以内经的经络理论来误解经方理论的一个产物。而且，他这些论述与临床实践也不能接轨，没有任何可取之处。

阳明病、不能食、以其人本虚·攻其热必哕·攻其热必哕（注）所以然者·胃中虚冷故也·（194）

注：《宋本》此条文如下：

阳明病，不能食，攻其热必哕。所以然者，胃中虚冷故也。以其人本虚，攻其热必哕。

胡希恕：他说阳明病要如果不能吃啊，你就加小心胃虚停饮，啊。那不能再撤热了。他胃本来虚，再撤热更不行了。所以“攻其热必哕”，哕就是哕逆，啊。那么什么道理呢？这就由于胃中虚而有冷饮的关系。

胃中虚不能攻伐。有冷饮，啊，你温中去饮的法子可以了，你…啊，你吃泻药这个不行。祛寒性药也不行了，苦寒的药也不行了。这就由于人本虚，所以攻其热他必哏的。这也就是告诉人呐，这阳明病如果不能吃你要注意，啊。不要拿起来就一二，看作一二实证，啊，片面的你就给吃…就攻，攻…这个攻啊，他都指着大承气汤。就拿起来就是攻破的药，这个是不行的，啊。因为尤其这个不能吃啊，大概都是胃虚多饮的病。今天咱们多讲一点，啊，今天这节儿都小，我们稍稍的来候一会儿，我再…再…再讲，喝点水，啊。多讲点，多讲点呀，他头前儿……（音频缺如）

李冠杰：这条在《康平本》里是降一字格的条文。

《宋本》由于把注解内容窜入到正文里去了，整个条文就变成了：“阳明病，不能食，攻其热必哏。所以然者，胃中虚冷故也；以其人本虚，攻其热必哏”。它也不嫌麻烦啊！

下边简单地做个分析：

如果仅从文字上看，《宋本》与《康平本》的条文一字不差。但是在语句的排序上出现了比较大的差距。《康平本》里的“以其人本虚，攻其热必哏”本身是旁注内容。要按着这个书把旁注内容窜入到正文里的惯例来套的话，这个注解内容应该在正文的“攻其热必哏”之前，至少也应该在这句的后边，紧接着这句才对，因为旁注是挎在这一句边上的。但是到了《宋本》里，一下子就把这一句调到条文的最后了。这只有一种可能性，就是王叔和在第二次整理的时候，他发现如果要按照惯例往里窜就会出现语言重复，语句也不通了，最后就用了这样的办法来做了一个调整。对原文和注解中的语句做这么大幅度地调整，从目前所知道的史料看，只有王叔和一个人可以做。如果说是其他人，比如宋代校正医书局的林亿那些人做的话，对注解窜入正文后所出现的重复一般是不动，像“攻其热必哏”两个在一块儿显得太重复了，他或许会删除一个，但也不至于把一整句排到后边去，

实际上还是存在着重复的问题。为什么这么说呢？因为林亿他们在这方面的态度非常严谨，不会做这么大的调整。包括一些方剂里明明少了药，他们都不去补上，而是作个说明，所以这肯定不是他们做的。如果不是他们做的，就只有王叔和可以做这样的调整。这也就印证了王叔和曾经两次整理过这本书，第一次整理完了就是《康平本》的样式了，第二次整理完了以后就是《宋本》的样式。

通过把《康平本》和《宋本》的条文做比较，我们还可以再一次证明《康平本》的真实性。同时还可以再次印证，只有从《康平本》改为《宋本》的可能性，而绝没有相反的可能。大家从这个条文去感悟就可以了。如果谁有可能对前后基本通顺的条文，把条文末了的十个字摘出来改成旁注，再塞到条文中间，而且还出现了“攻其热必哕”几个字的重复，没有人能做得出来。但是如果把《康平本》旁注的内容窜入到正文里，再做这样的调整合情合理。无论到什么时候真的假不了，从各个地方都可以证明它的真实性。

因为这条本身比较简略，所以我们可以结合临床来解读。

条文中的“阳明病不能食”，可以分为两种情况来看待：一种是单纯的阳明病，而且出现不能食的情况，比如里热太盛，以致影响到了胃肠的功能，可能会造成不能食；还有里实证达到一定的程度它也不能吃，像“胃中有燥屎五六枚”那样的。咱们学习过的，像单纯因为热引起的，比如大黄甘草汤吃了就吐，像包括调胃承气汤这类的方证也会影响到食欲，像大承气汤这种里实证严重的，也可能造成不能食，都有可能的。那么，如果属于这类的情况，就都得用攻法，或攻热、或攻下。只要方与证相应，它就不会出现不良反应。可是这条里论述是另外一个情况，是阳明病的同时又伴有其它类型疾病的存在，比如停饮证，在经方的治疗原则中，有里饮是不能用下法的。如果又误治，就有可能出现条文里论述的“攻其热必哕”，攻的话就会出现哕的情况，甚至都有可能造成下利不止的变证。

这个条文的注解内容是针对后一种情况所加的，胃中虚冷可以把它理解成有停饮了，所以不能用单纯攻热或者泻下的方法来治疗。

阳明病、脉迟、食难用饱、饱则微烦、头眩、必小便难、
此欲作谷疸·虽下之、腹满如故（注）所以然者·脉迟故也·（195）

胡希恕：“脉迟”为有寒呐，胃虚有饮，也有寒，这脉也迟。“食难用饱”，胃虚有饮他不能吃，啊，你要勉强吃，啊，那么要是饱的话，人就微烦头眩。里头停饮，脑袋晕，啊；那么里头蕴热呢？人就烦。“必小便难”，那么这个头眩什么道理呢？他停饮，这饮哪儿来呢？就是水不下行，小便难。那么这种情形“欲作谷疸”呐。就要发…古人对这黄疸呐，分谷疸、酒疸、女劳疸这么三种，啊。那么这谷疸就是消化不良这一类的，啊。里头又有热又有湿。那么在这个《金匮要略》他这么说的，所以，谷疸之为病，啊，寒热不食，发…啊，发热…发寒热，发热恶寒而不能吃，食者头就晕，啊，那么心胸啊，不安。不安就是烦呐，这就叫做谷疸，啊。应该用茵陈蒿汤这个法子来治疗。你们回头看看《金匮要略》那个黄…啊，那个黄疸篇上就有，啊。他说这一个跟他说的是一样。他这胃虚停饮，食难用饱，你要一饱了，心胸不安那个烦，啊，同时呢，脑袋要晕。他…他这个胃虚呀，他不认这个湿，胜不了这个…这个谷物，啊，他消化不了。消化不了就要蕴热他就要烦。有热又有湿，湿热相激就要发黄。他这个，由于发生于这个，啊，胃虚不能化谷这么一种情况，他所以古人叫做谷疸，啊，那么这个也一定小便难的。“虽下之”，所以这个，啊，实者可攻，虚者不能攻，啊。攻了，这个源起不是腹满嘛，这一个更满，啊。腹满如故。“所以然者”，这就是胃中虚冷啊，还是那一种意思了，啊，他是“脉迟故也”。所以阳明病我们遇着脉迟啊，啊，既可有实证，我们也应该虑其虚呀，啊。他后头，头前儿讲这个，后

头都有。他在头前儿啊，他都略略提示，作纲领提示一下子。

李冠杰：这是个降一字格排版的条文。

解读一下：

这个条文论述的，实际上不是单纯的阳明里热证，而是一种既有里热又有停饮证的情况。

“阳明病”，当然是指患者有阳明证典型的症状反应存在了。

“脉迟”，这儿特别指出了脉迟，出现在阳明病中，应该有它自己特殊的原因：一个是这种脉出现在阳明病中，不是典型的脉象，但并不是不可能，就是说阳明病有时（虽然它不典型）也可能陷于脉迟的情况。甚至大承气汤证这样重的里热里实的这种病，也可能会出现迟脉，这是一方面的原因。另一方面的原因，因为里有饮，里饮严重也可能造成这种情况。这个条文论述的，主要是指的是后者。

“食难用饱、饱则微烦、头眩”，由于胃功能低下，而造成胃中停饮所导致的这种饮食减少，如果勉强吃，也能吃下去，但是吃了以后，它就会发生头晕等一些不适的症状。

“小便难”，是停饮证的一个铁证，是停饮证的一个典型的症状反应。

“虽下之、腹满如故”，从这一句我们可以看出，在下之之前就应该有腹满这个症状，误用下法以后，仍然存在这个症。从这儿看这个腹满应该是因为胃虚，停饮所造成的，而不是因为里实证造成的。所以虽然使用下法，但是腹满不去。

这个条文所论述的这种情况，跟《金匱要略》里“黄疸病”里面那个茵陈蒿汤证比较雷同，只是没有发展到黄疸病的那种程度。茵陈蒿汤怎么论述：“谷疸之为病，寒热不食，食即头眩，心胸不安，久久发黄为谷疸，茵陈蒿汤主之”，跟咱们这个条文里面论述的比较接近。

从这儿也能看出一个问题，旁注“此欲作谷疸”的这个解释是非

常有道理，它具备了发生“谷疸”，也就是说黄疸的那种病理特征了。

但是后边的附注，“所以然者。脉迟故也”，它本身就明显带有一定片面性了。

阳明病、法多汗、反无汗、其身如虫行皮中状者，此以久虚故也、（196）

胡希恕：这个阳明病里热，他蒸汗外出，依法当多汗呐。那么如果他反无汗，这个原因也很多了。这一条就说是，他是虚。什么虚呀？精气虚。他也要出汗，没有汗，就像虫子爬似的，啊，他外边儿不见什么汗。“其身如虫行皮中状”，他热也往外蒸啊，他没有津液，津液少，他不出多少汗。这是什么道理呢？就这个人呐，津液久虚的原因。这个津液虚，胃也不太强啊。这也是肯定的，是吧。这个津液来自于…所以这个胃为水谷之海嘛，津液之源呐。他能不够消化水谷，这个津液就虚，他，脾…他是很久就这样子，啊。所以现在他得阳明病，他也反无汗。要这样子就不能吃承气汤了，啊，后头他也有。这一个他如果大便硬，只是根据脾约那种治法，吃点儿这个麻仁滋脾。

李冠杰：这个条文是一个降两字格的条文。

阳明病属于里实热证，因为人体需要以加快体液代谢的这种方式，来维持体内内环境的平衡。所以，常会表现为多汗多尿等症状。但是这个条文论述的，却是一种比较特殊的情况：患者有一系列的阳明病的症状反应，却无汗出，反而，出现了“其身如虫行皮中状”。这儿论述得挺有意思。作者对这种情况作了一个解释：“此以久虚故也”。这是由于人体长期处于比较虚弱的状态下，又罹患了阳明病，表现出的一种比较特殊的症状反应。

条文当中的“久虚”，指人体虚弱状态的时间比较长。

凡是长期陷于虚弱的这种人，必然会存在着一个共性，就是胃肠

功能肯定不好。因为人体主要的能量来源就来自于胃肠，从摄入的饮食当中来获取。如果胃肠功能不好的话，很自然就会造成人体能量不足。久而久之，人体就会陷于一种虚弱的状况，这是非常自然的事。但是，这种虚弱的状态不仅仅是各种功能偏于低下，常常是津液、血液也都处于一种比较低的水平。这个时候，如果发生了阳明病，他还是用加快体液代谢的方式来散发热量。可是体内的津血都不足，就会使人体形成一种欲汗不得的局面。一方面体内的水分，被热迫于体表；而另一方面，因为津血俱虚而达不到汗出的这个程度。

在这种情况下，患者就会有一种特殊的反应，皮肤下边好像有虫在里边爬一样，说不出的一种，挺难受。

我们从这个条文论述当中，可以去体悟人体患病以后的复杂性，或者我们称之为多样性。实际这个地方就论述了一种阳明病本来人体有了出汗的机制，但是他出不了汗，表现为无汗。这是比较明显的特殊情况。有的人不一定有特殊的这种情况，还有的人小便比较通畅的话，汗出也不会那么多。

这个条文论述的就是一种有出汗的机制，但是因为津血虚，达不到出汗状态这么一种情况。

在临床实践当中，这一类的问题比比皆是。比如：同样是芍药甘草汤证，但是不同的患者表现也不一样。有的患者表现为呃逆、打嗝；有的患者表现为胃痛；还有的患者表现为腹痛。下肢状态不好的患者，可能表现为两腿无力，或者两小腿肌肉痉挛这一类的。

总之，通过解读条文，就得深入地去理解人体患病以后，在临床中表现出来的症状反应跟病理之间这些关系，要逐渐地、深入地、全面地去把握这些，而不要试图简单化，复杂就让它复杂吧。

今天有个病人，他前年的时候，冬天咳嗽，干咳。他干咳有个特点：只是白天咳，晚上不咳。他还有一个特点，无证可辨。除了咳嗽以外，什么不舒服的感觉都没有。最后跟我说睡午觉的时候，脚有点

冷。那时候用的是小青龙汤合上麻黄附子细辛汤，就等于小青龙汤加了附子。他吃了几天，慢慢就好了，好了后一直持续这么长时间。今年他又犯了，还是那个症状，跟原先一模一样。他说：我还要吃那个药。你看他要吃那个药，你要是给改了药的话，他一吃就能吃出来，我就给了他很少一点的药。结果，吃了以后，他说：这次怎么不行呢？我说：我再给你好好看看吧。结果摸脉又浮、又数、又滑，他有里热了。我给他麻杏石甘汤合越婢汤加上桔梗汤。他有嗓子疼的感觉。吃了大概三四天吧，今天跟我说，明显得轻了。再吃几天吧，今天又给他带回一点去。

他这种情况，他这一次是外有表证，里有热；上一次是外有表证，里有寒饮，甚至还有点阴证。这两次，你从外表上看不出有任何变化，而且他的症状也非常相近。大家再去想想那种体质用药的学说，你怎么给他体质用药啊？怎么去分别两次的病啊？按照体质用药的话，那必须用一样的药。因为他没有变化，甚至症状表现都一样。那能通吗？不要试图把经方给简单化，它本身不是一个简单的事。如果能简单，当然简单就好了，不是那么简单就不要去简单化。但是，也不能去复杂化，实事求是。

阳明病、反无汗、而小便利、二三日呕而咳、手足厥者、必苦头痛、若不咳不呕、手足不厥者、头不痛、（197）

胡希恕：“他阳明病，这个无汗，啊，应该有汗，而反无汗者原因很多很多的。那么这一节呢？他这阳明病初病于阳明，他指着少阳病说的，他“呕而咳”他指着少阳病说的。少阳明啊，还相当明显，那么他有的时候他也…啊，不到这个他出汗的时候，他也无汗。“而小便利”说明里头是有热了。“二三日呕而咳者”，这二三日这是据这个全段说的。不是说是“反无汗小便利”以后有二三日，根本这个

病啊，就是二三日。二三日啊，他是由表传半表半里。那么这个时候里头是有热了，啊。但是没到那汗出的时候，怎么知道有热呢？他小便利嘛。“呕而咳者”这还是少阳病。少阳病涉及于肺他要咳，这个热可见往上涌得厉害。“手足厥”，这个厥不是一个寒厥，是热厥。咱们后头讲那个，到厥阴篇里头就讲了，这个厥有寒有热了。这个热，尤其这个少阳病，啊。那四逆散就是个柴胡、芍药、枳实、甘草，这四味药也治手足厥，那也是热厥。如果要这一个，啊，这个，所以这个…那个…那个…那个，热厥后头他有啊，“热深者厥亦深，热微者厥亦微”。他只是说厥而已，这个厥不会大厥的，啊。因为这个少阳病啊，津液丧竭。后头也有，啊，吃这个柴胡证啊，他说津液得通，胃气因和呀，后头有的。他津液竭，他不旁…啊，不旁达，手脚也厥，这个是由热的关系。那么由于这个热，有热，而且这热呀，往上攻，所以“必苦头痛”啊。所以呕而发热，头痛这柴胡证。假设，不咳不呕，手足不厥者”，既不是少阳病而热又不甚，那脑袋不会痛的。这个他就是就证来辨证的意思，是吧？后头有，啊，呕而头痛者，这是小柴胡汤主之。这就说明这个热在里头啊，它有上越，啊，有下陷，这么种种的分别吧。要是上越的时候啊，常常的造成这一个，啊，脑袋痛。但是没到这个里，啊，里热实的这么一种情况，他不汗出的，这一种不汗出不是津虚，啊。

李冠杰：这条在《康平本》是降两字格的条文。

“阳明病，反无汗，而小便利”，这论述的实际是阳明病的另一种表现形式。阳明病的病理是有里热，要散发里热，所以常常表现为汗出、小便频数等等的这类症状。但是如果还有另外的情况，比如小便一直非常通利，甚至有点偏于频数，体内的热量又不是特别严重，通过排小便这一种途径散发里热已经足够了，这种情况下也常常表现为无汗的情况。

大家看，凡是来自临床的东西，不管出自谁之手都很客观。在临

床中，那些属于白虎汤证、白虎加人参汤证这类病理造成的糖尿病，这是一种常见的现象，其他的像阴性证造成的糖尿病咱不去讨论。咱就说这种糖尿病，虽然不同的患者之间在病理上都属于阳明里热，而且津液虚的情况下发生的糖尿病，但是有的无汗而小便频数，有的有汗而小便基本正常，还有的既有小便频数，又有汗出。这样的病人我都碰到过，十几年了一直保持那种状态，有时午觉醒了都出一大身汗。要是这么看好像没有什么规律可言，但是其发病机制都属于里热，再去找其他的症状如脉、舌等，只要有里热，汗多一点也好，小便多一点也好，两样都多一点也好，都有可能存在的。具体到这条论述的是一种小便通利，却没有汗出的阳明病状态，从理论上说，这种阳明病的程度，没有那种既汗也多、小便也频数的那么重，程度上可能稍微轻一些。

“二三日，呕而咳”，这应该是少阳病的典型症状反应。特别是还给了一个“二三日”的日期说明，就更说明指的是少阳病了。

“手足厥者”，也应该把它看作是少阳病的症状反应。如小柴胡汤证和四逆散证，都有可能出现手足冷的情况。而且在后边的文字里，把“呕而咳”和“头痛”作为同一类相关联的症状来论述，也说明都是指少阳病而言的。

“必苦头痛”，还是要把它理解成少阳病。但是“头痛”这个症状，少阳病里可以出现，阳明病里也有这个症状，而这条里论述的正好是少阳、阳明合病的这种情况，“头痛”出现的几率就自然会比较高，所以这儿弄了个“必苦头痛”。

“若不咳不呕，手足不厥者，头不痛”。他把这些东西联系到一块儿了，说明这一套是一种类型的病，也就是说，如果没有这一系列的症状反应，它就不存在少阳病了。大家看看，论述症状里阳明病的症状并不是很重。那么，阳明病症状比较轻的话，头痛的机会就会比较低，所以这儿就来了一个论述：一旦没有出现少阳病，就不会头疼

了。

通过这条，可以看出降两字格条文的作者在文风上与另外两类条文的作者有明显的差异，现在不说理论观点就说文风上。不仅如此，从条文的写作上甚至可以观察出这个人性格上的某些特点，也可以略见一斑。值得庆幸的是有了《康平本》，我们得以把这三个不同的作者去进行比较，就凭《康平本》这种特殊的排版方式给我们带来的信息。如果说没有《康平本》的话，你去对比什么呀？现在好多人因为没见过《康平本》，或者还不重视《康平本》，看了那个“伤寒例”、“辨脉”、“平脉”，然后再看了这类条文，一口一个仲景如何如何，最起码这不是事物的本来面目。

咱们现在知道了这种排版的方式，在此基础上再重新审视这个条文，从论述风格上，这个条文可以说是拖泥带水、毫无经典论著的风范；从论述技巧上，这个条文不单单是内容上存在不必要的大量重复，而且语言上也如同绕口令一般，反复而呆板，让人感觉到很别扭。

阳明病、但头眩、不恶寒、故能食而咳、其人咽必痛、若不咳者、咽不痛、（198）

胡希恕：这个头眩呐，我们头前儿因为，他也讲了，头眩都是停饮的关系。这个胃停饮脑袋眩呐。可是热要是…那么有停饮，啊，你像咱们用麻杏石甘，啊，不是麻…啊，这个苓桂术甘汤啊，啊，起则头眩嘛，啊。吴茱萸汤也治头眩，他那个是，水气往上冲得凶了，他呕吐。那么这一个头眩就不是了，“但头眩不恶寒”，在这儿呀，这纯粹热。阳明病是恶热而不恶寒呐，这个人这个头眩要是与这个不恶寒来一起，这是热象啊，热攻冲上头，也头眩。这个我们，这临床上很…很要紧呐。所以咱们治头眩呐。有时由于热亢于上的；有由于这个胃有停饮，啊，而冲逆的；也有贫血性的。那一个咱们没讲呢，是

吧？要讲这个，啊，这个《金匱》上就有了，所以妇人这个临产的时候常昏冒嘛，冒也是冒眩嘛，是吧？那是贫血性的眩。一般呢这个停水，啊，或者是热往上壅逆的这种头眩，最多见。但是真正热他不恶寒。“故能食而咳”，这就跟着那个中风、中寒呐，那个辨证了。所以阳明病能食者，啊，为中风，里头有热，有热他也能吃。由于这个头眩，这个热上，亢…上亢得厉害，一定波及于肺而咳的。“其人咽必痛”啊，有热又咳，他嗓子，啊，因咳而伤，他要疼……（音频缺如）……当然他嗓子也不会疼的，啊。

李冠杰：这个也是一个降两字格的条文。

这个条文论述的，是以典型的阳明里热证为主的一种疾病状态。

“不恶寒”和“能食”，都是典型的阳明里热证的症状，“但头眩”和“咳”（咳嗽）放到这个条文里面，因为没有其他的证据来佐证它是其他类型的疾病，所以头眩和咳嗽都是因为里热上壅所致，就跟这次甲流一样，热得厉害，也造成咳嗽，直接就是热壅所致。这个咳嗽和后边说的咽痛，也是相同的因素造成的。但是这两个症状，这个作者认为，在里热达不到对上呼吸道有那么严重影响程度的时候就不会出现，也就是所谓的或然证了，如果不咳，咽就不痛。

像这类的条文，如果细推敲的话，这个“咳”会不会也是指的少阳病？但是包括这个“咳”和后边的“咽痛”，在少阳病里边都不是典型的症状，而且也没有其他的佐证。像这类的条文，作过多地延伸，徒劳，没什么意义。

阳明病、无汗、小便不利、心中懊憹者、身必发黄、（199）

胡希恕：这几段他光…专讲这个发黄。“阳明病无汗”，这个热不得外越，他无汗呐。小便再不利，这个湿也不得下泻。“心中懊恼”，里头还真有热，并不是没有热，啊。“身必发黄”啊，这就是我们开

始讲那一个了，啊，这就是郁热在里了。有湿有热，这两个结合起来他才要发黄的。

李冠杰：这是降一字格的条文。

“阳明病”，是典型的里实热证，人体需要以加快体液代谢的方式来散热，所以常常表现为汗出和小便频数。有时甚至还会出现汗多、小便也多，这种情况都存在。

但是也有例外的，这个条文论述的“无汗，小便不利”，就是其中一种。他表现的是阳明病典型的症状反应，但是，没有汗，而且还小便不利。实际上，这个问题就更复杂了。这不是一个单纯的阳明病，他有阳明病的同时，还存在有里饮的情况。

“心中懊恼”，这是热证的典型症状反应。栀子豉汤证常常有这个症状存在。这个“心中懊恼”在经方里面，常常指热扰胸膈，究其实，还是一个热证。

“身必发黄”，既有里热又有严重的体液代谢不良，所以，就非常容易发生黄疸病。条文论述的就是这个意思。

阳明病、被火、额上微汗出、而小便不利者、必发黄、

（200）

胡希恕：火更助热。那么这个人呢，只是额上微…微汗出，旁处没有汗，啊，所以这热也不得外越，还都在里头。而小便再不利，啊，这个水也不得去，所以也必发黄。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降一字格排版的条文。

阳明病本身就是一个阳性里热证，如果再用火攻的方法治疗，体外的火热会进一步加重体内的里热。既有外界的火热，又有体内阳明里热的炽盛，患者却表现为额上微汗出，实际上，等于无汗的状态，只是额头上微微出一点汗，这还算出汗吗？就说他没有汗出。同时还

有小便不利。既有里热又不得汗出，热不得越，同时又小便不利，这就说明体液代谢不好。通过皮肤出汗，也出不去；里热又这么严重，再加上用火攻的误治。这种情况出现黄疸，可能性是非常大的。

这类的条文，必是来自于临床实践。这就说明了阳明病的一种很特殊的情况。这里边有停饮的情况，不仅仅停饮的问题，他还没有汗呢。所以，阳明病准是都那么多汗的吗？不一定。

临床当中碰到这类情况，你找他有没有里热，很容易找的，脉象，舌象，包括二便，都能佐证的。

通过今天晚上的学习，我想大家是不是有这方面的收获，真正的患者在临床当中表现出来的，不像我们书上写的那么机械化、程式化。有时候他就会出现特殊的情况，尤其是在临床当中。

什么东西对我们把握这种情况最有用处呀？就是我说的经方病理辨证。你看看他有没有表证，有没有半表半里证，有没有里证，有没有水证，有没有气证，有没有血证；属于阴性的、阳性的；还是热性的、寒性的、虚性的、实性的。咱们今天讲的这些几乎都快涉及到了。是不是？那么你在临床当中，把这些东西如果掌握了、弄熟了，最终成了你自己的知识。我可以这么跟你说，或许你的疗效还没有那么理想、那么高。但是，你可以杜绝误治的发生。

阳明病、脉浮而紧者、必潮热发作有时、但浮者、必盗汗出、（201）

胡希恕：阳明病脉浮而紧，这是太阳伤寒转属阳明啊。那么脉还浮而紧，说明这一个，啊，伤寒为证很明显。那么即便转属阳明，也只能“潮热发作有时”而已。“发潮热”就是阳明病的一个证候。那么由于这个太阳病，这是乍传阳明啊。所以脉还浮而紧。虽然还发潮热，不是老那样子，也是一阵一阵的。“发作有时”，有时候发潮热，

不会，啊，始终发潮热的。始终发潮热那就是里实了，他这脉他绝不会“脉浮而紧”了。啊，这个太阳伤…那只是…那能够，啊，“表不解，微恶寒”而已，他不会还“脉浮而紧”的，这跟头前儿咱们讲那个是一样的，啊，“脉紧则愈”那一节儿是一样的。他这脉紧再发热恶寒这是表证，啊，完完全全存在了。那么即刻这一阵儿里头有热，也不会…啊，你像咱们说胃家实那个程度，还不到。即便发潮热，也是发作有时。“但浮者”，但浮者这个脉呀，就是不紧了，不紧了津液有所丧失了，那么如果也是太阳病还…还存在，这个……（音频 025 完）（音频 026 始） 我们对于治盗汗，所以咱们常常的，啊，一遇到这个，他就是黄芪就上来了。这个盗汗多有源于里热。所以咱们用那个小柴胡加石膏啊，也治盗汗，啊。但是，不是由于里热是不行的。有里热的很多呀。它怎么治个盗汗呢？他不治多汗呢？要多汗他不会再有这个…太阳病不会明显。这个也根据上边，啊。虽然脉浮，他要是一真正到阳明了，他脉沉实、沉大，啊，等等的。它不会再浮了。再浮整个这还是，啊，还在表呢，这个病大部还在表呢。那么大部在表，要是紧，啊，也只能是“时发潮热”而已；要是脉浮缓，这是太阳中风那种脉了，啊。那么一定，啊，他脉不浮紧了，他也没有汗，啊，那当然他是这个什么，是这个，津液有所丧失了，他一定有盗汗。

李冠杰：这条在《康平本》是降两字格排版的条文。

解读一下：

这条论述了阳明病中两种较为特殊的表现形式。

第一种情况，是表现为“脉浮而紧”，同时又伴有“潮热”，而且“发作有时”。这儿的阳明病，应该是指患者有一系列典型的阳明里热证的症状反应。但是“脉浮而紧”不是阳明病典型的脉象，阳明病如果现这样的脉象，常会伴有“潮热、发作有时”的症状。实际上这个症状与阳明病的“日晡所发潮热”属于同类的症状反应。用今天的语言来表述，意思就是阳明病当表现为“潮热、发作有时”的时候，

常会出现“浮而紧”的脉象，这比较客观。

第二种情况，就是阳明病如果只现浮脉，则常会出现盗汗的症状。

“但浮者”也就是指的脉象了，就是说仅现浮脉。言外之意是既没有紧象也没有洪大之象这类的脉象。“盗汗”指睡眠中“合目而汗”，就是说睡眠当中出汗的症状。

实际上这种症状和脉象之间不一定有稳定的对应关系。但是，学习这一条，重在理解阳明病的症状反应应该是复杂的、多样的。任何一种疾病的表现形式，都不是一种固定不变、程式化的，阳明病是这样，其他的病也是这样。至于条文里所列举的两组有关联的脉与证，在临床中是不是就准这样，是不是有稳定的对应关系？这个值得研究。比如“潮热发作有时”这种症状，在阳明病中实际就包括了“日晡所发潮热”这类的情况。“日晡所发潮热”是阳明病常见的一个症状，在这种症状下，阳明病常见的脉象也完全有可能出现，不一定仅仅表现为“浮而紧”。但是反过来，作者既然这么说，肯定在临床中有这类的经验，或许出现这类脉象的可能性比较大一些，几率比较高一些。从另一个方面看，这条的作者理论上是有将脉诊绝对化的倾向，不仅仅这一条，从降两字格的其他同类论述脉象的条文和辨脉法、平脉法综合来看，实际上它们的理论都属于同一体系，都有这方面的倾向。我们在后边的学习中还会结合相应的条文再做深入讨论。

阳明病、口燥、但欲漱水、不欲咽者、此必衄、（202）

胡希恕：“口燥，但欲漱水”，这个里有热呀，他渴。这个胃，胃有热，啊，他是要渴的，口中干，啊。那么只是燥而不欲饮，不渴。可是嘴燥的难受啊，愿意漱水，这是热不在胃，在血分。那么血分有热呢，啊，这个迫血妄行，他常常的鼻衄，啊，此必衄。

李冠杰：这也是一个降两字格的条文。

解读一下：

这个条文论述的，是患者在有里实热证的某些典型症状反应的同时，表现为“口燥，但欲漱水，不欲咽”这一类的症状。

“口燥”是里热伤津所致了，但是一般情况下，如果仅仅是因为里热造成的口燥的话，他会表现为口干欲饮，他想喝水。而这儿是“但欲漱水，不欲咽”，说明其中还另有原因。

咱们从人体的生理机能上来看，人体所有的组织器官的濡养，都要靠血液循环来实现。通常情况下，由消化道吸收的这些营养成分，包括通过呼吸道吸进去的氧气，食物里边的营养成分，都要随着血液通过动脉输布到全身各个组织器官，供应到每一个细胞。如果水份不足，人体就会处于一种，我们中医说的津液虚的状态，常常表现为口渴欲饮，这是人体的一种本能的反应。但是血液本身存在状态不良的状况，同样也会影响到体液的输布，这个时候并不是人体真正的缺少津液，而是有津液。血液送到的某些部位，输布的度与量不够，就会出现这个条文里边论述的这种特殊的情况。一方面，血液不能很好的尽职，使某些组织器官缺少水份，而使患者有枯燥的这种感觉，在这个条文论述的就是“口燥”了；当然这个“口燥”还有另外一方面的原因，有里热造成的这方面的原因，而这个时候人体的津液还没有发展到组织枯燥的那个程度。所以口燥的主要原因，是血液输布不良，它在某些部位啊，输布不到，就出现这么一种“口燥”，他口干渴，就是想喝水，但是他又没有真正喝水的那种欲望，换句话说，胃里面不要。它跟五苓散证不一样，它这也渴，但一喝水就觉得胃里边也不要水，不想咽下去，用水湿一湿嘴就觉得舒服一些，“但欲漱水不欲咽”，这是一种比较特殊的情况。

而从“此必衄”这一证，我们可以知道，这个条文论述的实际是阳明病合并了瘀血证，并不是单纯的阳明病。按照我们现在病理辨证这么分类的，血证也是单独的一种类型的疾病，它跟阳明里证，从优

先级别上是同级的。

这所说的衄血，至少有两个方面的原因所致：一个是有里热的存在，凡热证，人体内的血液循环都会加快，同时存在瘀血的话，就很容易在某些部位发生血栓。瘀血就是血里边不太干净，我们用俗话说就是血的质量不太好，有一些不太正常的成分，它在正常的循环过程当中，本来有了里热之后，这个循环就比较快，它可能在某些毛细血管就会发生栓塞，特别是当这种栓塞发生在浅表部位，比如鼻粘膜的毛细血管部位，栓塞后会在局部形成一个高压，当血压短时间内升高到毛细血管无法承受的程度的时候，就会出现血管破裂，这就是所谓的衄血。

实际上在临床当中这一类的情況，不仅仅局限于鼻衄，如果这种情况发生在消化道内，就有可能出现吐血、下血；如果发生在呼吸道内，则可能就出现咳血；出现在泌尿系统，就有可能出现尿血；出现在皮肤下，就会出现紫癜之类的；要是一旦发生在脑部，那就有可能是脑溢血了。所以说凡病人有这一类的症状的，咱们就得细诊，它有没有比较重的瘀血证。

阳明病、本自汗出、医更重发汗、病已差，尚微烦不了者、此必大便硬故也。以亡津液胃中干燥、故令大便硬、（注）当问其小便日几行。若本小便日三四行。今日再行。故知大便不久出。今为小便数少。以津液当还入胃中。故知不久必大便也。（203）

胡希恕：这…他这几个阳明病都不是真正阳明病啊，这一节儿更是了。他这个“本自汗出”的病，啊。本自汗出的病还是表证啊。要是阳明病他再重发汗，他不会病已差的，阳明病你越发汗越坏呀，啊，他忌发汗。本自汗出的病就是，那还是太阳中风了，是吧？那么太阳中风应该用桂枝汤发汗，也不能用这个…啊…其它的药发汗，这也就

是发汗不合法，他不能用什么，较比重的发汗药。那么虽然病差了，这个人“尚微烦不了了”，啊。这个表不解，他要烦，表解了不应该再烦了，还“微烦不了了”有一些，这就是，啊，由于汗多亡阳，胃中干的关系，啊。这你要问一问吧，一定大便硬的关…里硬故也，啊，“此必大便必硬故也”，这是发汗造成的。所以他底下有解释，这一个不要，啊，当阳明病来治来。这就是人为亡津液，啊，这个发汗呐，啊，不合法，重发其汗了，那么胃中干燥，所以才使大便硬。那么这个时候“当问其小便日几行？”就是一天呐，几次小便。这个平时啊，本来是小便日三四行，今日再行，啊，故知大便不久出。这没有关系的，这个逐渐呐，津液恢复，啊，你这大便还是要有的。那什么道理呢？现在，这小便呐，次数少，那么次数少了，他这个津液，啊，里头就能够积蓄起来了，“以津液当还入胃中”，这胃里头津液也会恢复的，“故知不久必大便也”，将其这一个津液完全恢复了，啊，他是能大便的。这一个他不是阳明病，阳明病没有不能治…没有不治的，是吧？他不是因热结的。那么他也冒一个阳明病是什么道理呢？他冲这个汗出多，啊，这个“本自汗出”。这个后头也有，“本自汗出”啊，所以这个太阳中风他是自汗出。如果汗出多，也为太过，太过者阳绝于里，他就要得脾约证。他冲这一点上似是而非。就这个自汗出啊，这阳明病法多汗呐，所以他也冒着以阳明病。他底下他让你细分了。那么由于他还是病在表啊，所以他用发汗。可是但发汗不得法，他是重发其汗。本来有汗又重发汗，他这个张仲景所说这个发汗呐，都是麻黄剂。那么虽幸而，啊，由于发汗这个病已解。差就是解了。但是只是有点微烦而不了了，啊。这，要是阳明病你要是发汗，他不会这样子，那越发汗，啊，那越伤津助热，那是越来越重的。我们根据这个全文看呐，这阳明病不是个真正的阳明病。他这个书有的是，你比方这个伤寒吧，有的时候不是太阳伤寒，他就由于不汗，啊，没有汗，他就叫伤寒等等的。他“形似伤寒”，他也常这么说。

所以我们就这个全文看呐，他不是那码子事。不是咱们说的这个，啊，胃家实那一个蒸蒸身热自汗，你再发其汗，没那么个治疗法儿，那一个也不会得这么个结果，啊。这个要…要注意。

李冠杰：这个条文在《康平本》里，是降一字格排版的条文。

咱们解读一下：

对于这个条文的“阳明病”，我们要加以客观地分析：从整个条文论述的情况看，这是一种本来就有汗出，又经过“重发汗”以后，这个疾病基本痊愈，而出现“大便硬”，并且“微烦不了”的这么一种情况。如果真正是单纯的阳明病，别说“重发汗”，就是施以一般的汗法也都是误治。应该不会有“病已差”的情况出现，或者说很少有这种情况。

这里的阳明病，论述的是“医更重发汗”以前的疾病状态。那么他说的阳明病，是不是真正的阳明病，值得研究。所以条文中的“阳明病”，我们应该存疑。仅凭他论述的这些症状看，至少应该是太阳阳明合病，比如麻杏石甘汤证。应该是类似这样的症状。

“本自汗出、医更重发汗”，患者本来就有汗出，但是医者又给予发汗，应该是不当的治疗了。这个“本自汗出”，可能存在多种情况：一个就是阳明病的汗出；第二个是表虚证的汗出；另外呢，还可能是太阳阳明合病的汗出。比如麻杏石甘汤证或者越婢汤证的汗出。但是，无论是哪一种情况，如果“重发汗”，都是不恰当的治疗。只有一种情况，在病理状态上跟他论述的有点接近，大青龙汤证。但是大青龙汤证没有汗出，如果有汗出的话，绝对就不是大青龙汤证了。所以只有大青龙汤证，可以“重发汗”，但是这儿论述的却不是。

再深一步地想，再分析一下，这中间很可能还会有一个治疗方药的问题。既然是这样的一个病，又“重发汗”，怎么会好了呢？他用的是什么方剂？我们现在就不好说了。

这儿“病已差”，经过“重发汗”以后，疾病的症状基本消失了。

从治疗结果上看，这个“重发汗”使用的方剂和条文里边所谓的“阳明病”之间，应该存在着一定的对应关系。要不然的话，不会经过“重发汗”以后，反倒是好了。无论他方与证是不是相应，或用的是何方剂，我们现在已经不得而知了。

但是，在“本自汗出”的情况下，再予以“重发汗”，有一个结果是肯定的，必然会造成严重的津液虚损。津液虚损以后，就出现了“尚微烦不了者”。从前文的“病已差”和后边的“故令大便硬”来分析，这儿的“烦”，也只不过是因大便不通所造成的。因为前面已经说了，病基本的症状已经消失了，要不然的话，不能称作“病已差”。那么这儿的“烦”，大致就是因为大便不通造成这么一种情况。

作者也做了相应的病理解释：“亡津液胃中干燥”造成的。

旁注“此必大便硬故也”，正文里边有“故令大便硬”这个论述，所以这个旁注没有一点实际意义。

后边这个附注说得很形象。它用形象的论述和具体的方法，判断这种情况下，人体津液是否恢复，他介绍了这么一种方法。反映出古人在长期的临床实践当中，积累了通过对人体症状反应来判断病理状态的丰富的经验。

津液在人体体内本身是一种代谢性的东西，需要不断地吐故纳新，而正常的人体，这一过程既是动态的又基本是守恒的，摄入的水分和排出的液体之间存在着一定的比例关系。在一定的范围内，你摄入多少水，就相应地会排出多少。你摄入得多，排出的就随之增多，虽然排出水分的路径不同，出汗是一条路径，小便也是一条路径，如果说话多了，通过口腔也往外挥发一些水分。但是这个总量跟摄入的水分应该是保持一定的比例状态的。夏天我们出汗比较多，小便就相应地减少（正常的人）；冬天，基本上就没有出汗了，小便就显得多一些。这个附注内容就正是将这种自然规律应用于临床诊断的一个实例，还是比较好的。

伤寒呕多、虽有阳明证、不可攻之、（204）

胡希恕：“呕多”，呕多属少阳啊。这个少阳病不可汗，不可下。那么这个少阳阳明呢，常常这还是带着呕的。如是呕多，要是微呕那个时候，也有攻的时候啊，啊；但是呕多，那说明少阳病那还存在呀。那一个虽有阳明证，那也不过少阳阳明并病而已，我们应该从少阳治，不可攻之。不可冒冒失失的就给吃承气汤。

李冠杰：这条在《康平本》是降一字格排版的条文。

这个条文论述的实际上是一种三阳合病的状态。

“伤寒”，在这儿就肯定是指的太阳表证，也暗含着患者存在某些表证的症状反应。

“呕多”，这儿不仅仅是一个呕，因为在太阳病里有时候也可能出现呕，这儿特别强调了“呕多”。实际上经方理论中，“呕”常常代表有少阳病的存在，这儿就是指还有另一种类型的疾病。

“虽有阳明证”，就是说还有阳明病的症状反应。虽然没有说具体的症状，但是它肯定有，否则这句话就没有用了。

在这种情况下，“不可攻之”。一般情况下，条文里凡说“攻之”，大部分指的就是泻下。但在这一条，清热的方法也可以包括在里边。

在经方理论里，三阳合病应该取少阳治之；或分步治，先单纯治少阳，剩下的其他余证再行治疗；三阳合病要判断准的话，三种疾病同时治疗也不是不可以。比如今天，我还给病人用了小柴胡汤合上麻杏石甘汤，实际上这就等于是治疗三阳合病的一个方子。如果在三阳合病的情况下，单纯地用发汗或是泻下、甚至说清热，都属于误治。所以条文最后的结论就是“不可攻之”。

阳明病、心下硬满者、不可攻之、攻之利遂不止者死、止者愈^①、（205）

注：“止者愈”《宋本》作“利止者愈”。

胡希恕：这个更重要，所以心下痞硬，啊，心下硬满，这个这是胃虚，用人参的一种证候。咱们头前讲很多了。他这胃虚啊，他这邪气、水气都往胃这一块儿聚。这个胃这个地方儿，又硬又满。这个胃家实，咱方才不也说，也硬满。那么只是硬满，没有其他的热象实象，啊，这一个是人参证啊。应该用…啊，补中健胃的人参这一类的药，万不能攻。这个虚以实治，了不得呀。虚证当实证来治…来治来，“利下不止”，啊，那非死不可。“攻之，利遂不止者死”。他本来就虚嘛，当实证治，啊。“利止者愈”，若幸而利止，这还可以好的，啊。

李冠杰：这是个降两字格排版的条文。

咱们解读一下：

这个条文论述的并非单纯的阳明病，仅仅是“心下硬满”这个症状，你还不能说它不是阳明病。但是后边有“攻之利遂不止”，那么“心下硬满”就不是阳明病的那种里实证所造成的“心下硬满”，应该是里虚证的硬满，也就是我们常说的人参证，同时也可以佐证，这个“攻法”必是峻下的方剂，要是一般的也不至于出现这么严重的后果。

为什么要用这种泻下剂呢？按推理患者应该是存在大便不通的情况。所以这里的阳明病，主要是指大便不通，因为没有别的症状。如果病人真的存在阳明里实热的话，一般的“下之”，也不至于造成“利遂不止”而出现人命的这种情况。到这里有关阳明病的论述，咱已经学了二十多条了，好多都是降两字格的条文，通看一下，这位作者所论述的阳明病，有相当一部分，确确实实是用大便硬来界定的，在理论上有这种趋势。但事实上阳明病的病理：是阳性的里实热证。

它的典型症状反应“大便硬”，并不一定是必见证，可能是常见证，但不是凡阳明病必见大便硬。而且有的很典型的阳明病方剂中，还可能出现下利的症状，比如大承气汤、小承气汤，这都是典型的阳明里实热证的方证，但这两个方证里面，都有存在下利的情况。仅仅是用“大便硬”来界定阳明病，是片面的。阳明病是由一系列的阳明里实热的症状组成的一个病理范畴，不是一个简单的“大便硬”就能够界定为阳明病的。实际上作者自己在这儿的论述，也有这样的问题存在：看着像阳明病，大便不通，你要是“下”还真不行，用治疗阳明病的办法不行，这本身就佐证了这个问题，就是大便硬有时候，不一定是阳明病。另外，这个条文最后一句话，“止者愈”这一类的论述，有点太机械了！利遂不止的就得死，自己止住的就愈？自己止住的是一个阳明病，这个“心下硬满”的性质跟“利遂不止”的性质就变了，这么搅到一块儿论述，有点不太妥当！

阳明病、面合赤色、不可攻之、必发热色黄者、小便不利也、（206）

胡希恕：阳明病，面合色赤，啊，不可攻之，面合赤色，色赤这都行啊，这个颠倒着也没什么。必发热色黄，小便不利也。这个颜面红啊，啊，“面合赤色”，面合赤色就是“缘缘正赤”那个意思，啊。在太阳篇咱们讲过。这是“阳气怫郁”在表啊。这还是要出汗，出不来汗，啊，他脸发红，啊，发红色儿。这小发汗法儿才行呢，啊。这一个表证还有，你不要吃泻药。假设要是攻之的话，“必发热色黄者，小便不利也”，必发热色黄，这个“者”字儿不应该搁这一块儿，啊。所以他这个书这个字啊，啊，抄写转印呐，常常有些错的。那么一…一攻的话，邪热内陷，虚其胃，水谷不别，小便再不利，热与水相郁要发黄。这都是说的这个阳明这个泻下的禁…应该，啊，戒的这么

几条。心下硬满呐，阳明呕多呀，啊。所以我们在临床上啊，不要片面看问题的，要全面看。因为讲这个阳明病啊，他是以攻为主治的，就是攻下为主治的。他头前儿啊，有些呀，不可妄攻的，你不得不知道。就像我们讲那个，太阳病他是发汗，啊，为法，但有些不可发汗的，你必须得，啊，要知道。那么阳明病他搁这么几…这…从这以上，他都是对于阳明病，各个方面他概括加以说明的，啊。但是有一些条文呐，啊。他这因证辨证啊，有的…像我们说那一个，啊，“呕而咳，手足厥者，必苦头痛”那都是的，啊…你像那“头眩不恶寒”，这个地方都是因证辨证，啊。头眩这一个，本来是，常常的这是一个，啊，胃 有停停水常有头眩；但是不恶寒这个头眩呐，它是热。这个热它往上攻，他脑袋也眩。那么，所以这都是，啊，这在临床上也都挺好。他就是头前儿讲头眩了，啊，由于不能食，啊。那么有一些这一个，啊，欲作谷疸的，头前这个食难用饱这个头眩。他在这儿… 马上他就是…所以他这个书好就好在这样子。不让你认为头眩呐全是胃虚有停饮的这种情况，啊。那么也有这种情况。也有这个热往上涌的厉害，也头眩的，啊。他这个辨证他到底下讲了。

李冠杰：这也是一个降两字格排版的条文。

下面我们解读：

这个条文论述的是一种太阳阳明合病的情况。

这个“阳明病”，是指的有里热证的症状。肯定有这种症状，如果没有里热，误下之后不会出现色黄的情况。如果里实证严重的话，下了以后，也不至于出现如此严重变证。所以这儿的阳明病，主要是指的是里热证。

“面合赤色”就是满面潮红。在其他条文中这类的论述：“面色炎炎正赤”。在经方里面常常用来表示“有表证欲汗不得”的症状反应。

那么按照经方的治疗原则，这个条文论述的这种情况，既有里热

又有表证，得先解表后攻里；或者解表、清热同时进行。如果里实不重，用“泻下”的方法治疗，就等于是误治了。这个条文所列举的，就是因为误治，所发生的“小便不利”。而且这时，既有里热又有小便不利，就容易出现“色黄”的情况。这里的“必发热”，实际上还是表证未解的情况。另一方面，里热亦未除，也是造成发热的因素。

“色黄者，小便不利也”，这是误治以后，发生了体液代谢障碍，再加上有里热未除，所以容易发生黄疸。

那么讨论一个具体的症状：面色发红。一个小伙子，他的症状是：咳嗽，满面红。本来是白白净净的，稍微有一点情绪激动或是活动，就明显得满面特别红。给他把脉、问诊时，他的脸说红就红，平时不红的时候，局部比常人红色要明显。他当时有明显的柴胡证，我给他小柴胡汤加石膏，吃了五六天，所有的柴胡证都没了，感觉也比较舒服，食欲也改善了，那时干呕比较明显，现在也没有了。但还是有点咳嗽，面红，而且一点汗没有。后来我就给他大青龙汤开了三天的，（并且）一再嘱咐他，吃了以后，如果出了汗，剩下的药千万不要放着，一定要扔掉！防止他以后误服。后来，他把这个药都吃了，大概吃到第二天的时候，稍微有一点汗出，他始终没有大汗出！这实际上是他的病稍深一点，另一方面就是方和证相应。要是稍微表没有那么实的话，那吃了大青龙汤肯定要出汗，弄不好就要出大汗！结果呢，所有的症状都消失了！昨天，他又过来了，和我说：前边吃了你的药，我这一年多什么事儿都没有，现在又开始闹病了，还是脸发红。这次，症状就比较轻微，基本上就没有咳嗽。后来我就问他，他有口苦，脉弦细，舌有点发红，舌苔薄白。他这次的主诉是胃中不舒服，而且呕吐两次。我给他四诊完了以后，就给他柴胡加芒硝汤，因为他大便好几天了不解，而且解的时候，也比较难，就给他柴胡加芒硝汤。

那么这样呢，就反映出一个问题，在这个病人身上，现在没有一点表证，但是他有里热，他面部发红，除了体质上有这方面的倾向，

比较容易出现这一类的症状。面红也不一定准有表证，表证的症状，他一点都没有。

阳明病、不吐不下、心烦者、可与调胃承气汤、①（207）

注：《宋本》此处有调胃承气汤方及方后注，此从略。

胡希恕：“不吐不下”，这一他针对这个栀子豉汤说的。“发汗吐下后，心烦不得眠”，那是虚烦呐，啊。他经过吐下之后，里头没东西了，啊，所以这个烦他是虚烦。那么如果，有阳明病的外观，啊，就像咱们头前儿讲这个，确定为阳明的这个病形，是吧？外证是发热汗出，不恶寒但恶热；那么他这个腹证呢，就是胃家实，是吧？那么这一类的阳明病，没经过吐和下，那么这一种烦躁这是实烦，啊，胃家实这一种烦，所以可与调胃承气汤。那么这一个他也是简文呐。这一个调胃承气汤这个药，因为头前儿也讲了，是吧？这在这个承气汤中里头，它是比较，啊，最轻的一个泻下剂。那么调胃者，就胃不和，啊，而用这一个方子来加以调。看其起这个，起这个方名啊，不像个大泻下药似的，那么主要的在甘草这一味。这一个大黄、芒硝，啊。大黄配合芒硝这个泻下相当的重啊。这个大黄这个药它能通下，是吧？它刺激这个肠粘膜蠕动啊，它使这个粪便很快往下走。那么这个芒硝呢，它能够软坚去热，所以，里热结，啊，成坚块儿的东西，它能够把它稀薄了。所以这两个药合到一起，这个泻下…泻下的力量相当的重。古人有一句话嘛，说是大黄不配伍芒硝啊，就像这个快刀载刃似的，快刀不开刃子，啊，他发钝。那么这两个搁到一起呢？这个泻下力量非常猛峻。可是配合甘草这个药，它就能够缓其这个猛下。这个甘草这个药啊，那么我们在这个临床上，是吧？在这个疾病的有这种急迫的情况，比方说痛的急迫，啊，或者是各方面的急迫吧，比方烦躁急迫等等的。他能够缓解症情的急迫。你像咱们反复睡不着觉

啊，啊，或者肿痛的厉害呀，所以甘草它也缓痛啊，都是这个，以人体急迫的病情，而有这种情况，我们用甘草。这是对于这个治疗方面说。那么它对于这个药力呢，它也起缓…缓解作用，啊。所以咱们用这个泻下药，要是配合甘草不会虚脱的，啊。所以它叫调胃承气汤。它使这个药啊，这个作用缓缓发作，所以它调和胃气。所以这甘草啊，啊，这个药我们在临床上这个，啊，这个观察也是这样子。如果大泻下，啊，大利尿剂，让他快，甘草用不得。你看那五苓散，是吧？它是利尿里头最厉害的。猪苓汤，都没有甘草。你像大承气汤、小承气汤，也都没有甘草，那就利于速下。这个调胃承气汤，你搁个甘草它叫调胃，啊，它就是缓于调之的意思。那么这个方剂是不是大泻下呢？是的。你看这个份量就看出来了。这个大黄它是四两啊，四两，那古人一两合现在就是三钱，咱们现在用这个克计算就是 9…9 克；那么 4 两，三四一两二。这一两二是顿服啊，这个药很重了。啊，你看他写的后头是“顿服”，我认为这个是错的。我们在太阳篇里头那个调胃承气汤，他说是“分温再服”，两次，两次也够重的了，6 钱大黄，也就不轻了。而且这个芒硝，这是个错字，“半斤”错了，“半升”。古人一升啊，就是这一个，咱们这个小一点的茶杯，就一茶杯；半升呢，就是半茶杯，啊。它这个“半斤”呐，更…更重了，但是半茶杯也不轻，是吧？他这要是顿服的话，那就了不得，配合一两二的大黄，啊，那么就是有甘草，那也不行。所以这个，古人这个方子啊，我们不要死于他这个分量。那么根据用这个调胃承气汤呢，这几个承气汤都是啊，“少少与之”，啊。虽然这个方剂量挺重，一回别给他吃那么些，也行。我们在临床应用呢，一般我们来用这个调胃承气汤啊，这个大黄顶多是用四钱，再就是…就是三钱，就是现在说 9 克、10 克，这样儿就行了；这个芒硝呢？它是分冲了，咱们现在是两剂煎法了，那么芒硝呢可以搁 12 克，啊，一回搁 6 克，两煎嘛；这个甘草搁 6 克。这是一般用这个调胃承气汤，这个份量就

蛮好的。那么遇着轻病呢，我们这一个每一次，啊，就是一煎药也可以分两次用嘛，就是“少少与之”，那么如果遇着这个重症，我们也可以根据这一种情况，啊，要加这一种泻下药。他这个书啊，是有些传抄错误，这个事儿是有的。那么他这个份量也是一样的，啊。他古人说是匀两次吃，就是两剂。我们就…啊，要是两剂大黄这是四两，啊，一剂就是二两，啊，二两就是6钱嘛，那么够重的，是吧？所以我们在用的时候，不必准按着这个份量。

李冠杰：这条文在《康平本》是降两字格排版的条文。

解读一下：

这条论述的是阳明里实热证，没有经过吐法或者下法治疗，患者以心烦为主要的症状反应。这类的情况可以用调胃承气汤来治疗。

这个条文可以理解为调胃承气汤证与栀子豉汤证的一个鉴别点。两个方证从病理上比较接近，病理上接近是从六经或者八纲来分的，但是如果用病理辨证体系来分，两个方证的差别还是比较明显的。栀子豉汤证是以阳性的半表半里虚热证为主，有时候也会存在里热，但是里热证绝对是次要的；调胃承气汤证是以阳性的里实热证为主要的，基本上没有半表半里热证，如果有的话也在其次。

实际临床中，两个方证的表现差距是比较明显的。我把临床统计资料做了一个对比，因为比较繁琐，直接说结果就行了。这两个方证因为在病理上比较接近，所以有许多症状反应比较接近，但是也各有各的明显症状特征。比如调胃承气汤证，它是以便秘、烦躁和腹部硬满为典型的症状反应；栀子豉汤证，它是以心烦失眠，胸中痞闷（就是心中懊恼）这类症状为典型症状反应的，这是从字面上分析。那么在病理上比较，这两个方证属于一虚一实，所以在辨证上并不是特别困难。比如栀子豉汤证，常常会有误汗，或者误下，或者是有其他的导致人体虚弱的原因，或者人体本来就比较虚，常有这方面的原因出现热证。在这种情况下如果再具体到方证，像栀子豉汤证常常会觉得

食道或者胸里边有热辣辣的感觉，一种像是喝了砸的蒜一样，总是说不适的部位，集中在胸部的机会比较多。调胃承气汤证会表现为肠胃部的一些症状，这个还是比较容易辨别的。

阳明病、脉迟、虽汗出、不恶寒者、其身必重、短气腹满而喘、有潮热、有潮热者·此外欲解·可攻里也·汗出者·此大便已硬也·手足濇然汗出者、大承气汤主之、（208）

注：此条文《宋本》如下：

阳明病，脉迟，虽汗出不恶寒者、其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也。手足濇然汗出者，此大便已硬也，大承气汤主之。

若汗多、微发热恶寒者、外未解也、其热不潮、未可与承气汤、若腹大满、不通者、可与小承气汤、微和胃气、勿令至大泄下、（208）

大承气汤

大黄四两酒洗 厚朴半斤炙去皮 枳实五枚炙 芒硝三合

右四味、以水一斗、先煮二物、取五升、去滓、内大黄、更煮取二升、去滓、内芒硝、更上微火一两沸、分温再服、

（注）得下余勿服·

小承气汤^①

注：《宋本》作“小承气汤方”。

大黄四两 厚朴二两炙去皮 枳实三枚大者炙

右三味、以水四升、煮取一升二合、去滓、分温二服、（注）初服汤·当更衣·不尔者·尽饮之·若更衣者·勿服之·

胡希恕：“阳明病，脉迟，虽汗出，不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘”。“而喘”这是个句号，头前儿这几个都应该是一个逗号，啊。所以这个…这个书啊，这个句子要弄不清啊，也都给人家解释错了。有潮热者，此外欲解，可攻里也。手足濇然而汗出者，大便已硬也，大承气汤主之。这是一段。这个脉迟啊，这个迟，数之对，跟这个快脉、数脉。那么数是有余的脉呀，迟为不及的脉呀。一般这个不及的脉，大致都是主寒，主虚这一类的不足之病。所以阳明病，我们遇着这个脉啊，要当心其虚呀，这一段说的主要是这个，啊。所以阳明病，脉迟，虽然汗出，不恶寒者，这是阳明病的外证俱备了，啊。阳明病，汗出、不恶寒、但恶热是吧？那么虽然见其汗出不恶寒，阳明病的外证已备了。但是，由于脉迟的关系，他里头不会结热太甚的。

“其身必重，短气”，其身必重者就是外有湿。这个湿在人的这个组织里头人身上就沉，啊。“短气”者是内有饮。这《金匱要略》上的，所以病人这个食少饮多呀，啊，这个水停心下，甚者则悸，厉害的时候，心跳，咱们说水气凌心嘛，啊，那古人那个…那个术语呀，啊。微者，就是轻之话，也悸，停水少，所以这个，这个短气还是里有微饮，胃还有停微饮。“腹满而喘”，它既是停饮，他这个里边的结实，当然不是那么实。这个“腹满而喘”，实证，啊，如果里头实的厉害，往上压迫横膈膜 他也喘，也满。那么这一个呢，他是热往上壅之象。他既胃又有停饮，同时这热再往…再涌，啊，热再涌，那么这两项结起来也能使着腹满而喘。那么这一个言外，在这一个情形之下“不可下也”，啊。所以这个…这个文章啊，他古人这个文章他净，啊，净是要、要、要皮管吗。它一个虽字，这个“虽”字是个否定口气呀。

“虽汗出，不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘”，那么这一个情况，全是不可下的一个证候。到这一块儿他是一句，啊。他那个，暗…他那个他暗示啊，假设阳明病脉迟，啊，恐怕他虚。他要有这些证候的话，没实到家。这一个我们头前儿上一次不讲了一个，啊，“系

在太阴”嘛，这个病传于这个里，就是胃肠之里呀，他这个时候啊，假设这个人，素日里头，啊，多湿多饮的人，就是有，里头有水。那么如果这个湿胜过这个热，这个邪热是传里头去了，那么他就要发生太阴病，啊。太阴病就腹痛、下利，啊，他就发生那一种情况。如果热要是胜湿，所以这个阳明病他是法多汗呐，他这个水火这两个东西它不同时存在的。如果热盛了，它伤人津液，一方面出汗，一方面小便数。那么他这个…啊，这个体…体外呀，他没有什么津液了，他身子不会沉的。沉，说明还有很多的湿呢，啊。所以这个时候，里头他不会那么样子实的，这个热结不会那么甚的，啊，那么这个情形不可下也。“有潮热者”，啊，这个“潮热”并不是“日晡所”那个时候发热叫“潮热”。这一个也有人给净给解释错了，认为“潮”是主“信”，到时候发热叫“潮热”，这错的。这个“潮”啊，就说明这个，啊，来势汹涌这一种热，就热之甚也。我们常比方，小说上常有啊，说这个兵马来的…其来啊，如潮水一般呐，嘿！如潮水一般，就言其这个势又众，啊…又多。这个阳明病这个热呀，就是潮热，蒸蒸发热嘛。他如果有这一种的热，正说明这个“此外欲解，可攻里也”，这个时候可以利下。但是利下，是不是搁那一种方剂？这在原则上讲可以下，但是还不一定。如果“手足濇然汗出者”，这个阳明病法多汗，身上是早就出汗了，手足也不断出汗，绵绵有汗，那么这一个说明呢，这是大便已硬之候，大便，啊，都结…就是都燥结了。大承气汤主之，这才能用大承气汤。这个大承气汤这个药泻下猛峻呐，啊。那是要慎重用啊，啊。必须有潮热，而大便也硬，那么大便硬他有多种证候啊。那么这个“手足濇然汗出”这也大便硬的一种证候，啊。它大便这东西在里头呢，它这个外证上的反应啊，“手足濇然汗出”。那么就像我们方才所说的这个，这个阳明病他是热盛，他是使着津液尽量往外走，那么里边不但不能有水了，而且也确实干了。那么这个时候这个“阳明病脉迟”怎么解释呢？所以这个不及的脉也常主有余，这个

有余到一个相当程度，啊，那么这个人的这个津液是大伤了，这个脉也迟。所以这个迟脉，在…尤其这个书里常说营血…“营气不足，血少故也”，所以脉迟。那么这个脉迟，这真正的可下之脉了。开始我们要遇着脉迟……（音频缺如）“若汗多微发热恶寒者，外未解也”，假若，啊，他说上面，汗出的是不少，阳明病法多汗嘛，那么也…发热呢，不是潮热，是微发热，还有多少恶寒，这一个“外未解也”。外未解也，这个也不能用泻药啊。啊，得先解外了，啊。他这底下有一个，啊“宜 法与桂枝汤”这是对的，啊，这应该说用桂枝汤主之。这一个他都没明说。这一个因为我们头前儿学过了，咱们知道了，说如果有表证又有里证，这就是太阳阳明并病，那么表未解呢，宜先解表而后攻里，这是定法，是吧？头前咱们讲过了，所以来这儿就不详细说了，他只是说个“外未解也”，当然不可用承气汤了。“其热不潮，未可与承气汤”，这个只是微热，啊，那不行。准得这个热，有潮热。其热不潮，你看这个…这个字，也不是指着日暮那个发热呀，啊。热不潮啊，不到像潮水一般那个热，那么这一个不要与承气汤嘛不用说大承气汤，小承气汤也不行。这是陈述以前这一个“有潮热者，此外欲解，可攻里也”，可攻而已，啊。那么热不潮呢，连攻都不能，未可与承气汤。“若腹大满不通者，可与小承气汤”啊。如果没有潮热，真正大满，啊，腹胀满而大便不通，那也只能够小承气汤和其胃而已呀，也不能用大承气汤，是可与小承气汤。这个小承气汤它是一个，啊，就是厚朴、枳实、大黄三味药了。它也能通便，它消胀力量相当的强，它有厚朴、枳实嘛。微和胃气，勿令大泻下。啊。这个，有的书就没有这个“至”字，这个他搁个“至”，“勿令至大泻下”。微和胃气，那么这一个里头呢，也就是不能尽剂了，就是能够用…按他这个原方子份量，就是少用。那么这个很细了，这个他分析大承气汤、小承气汤，啊。这个张仲景这个书啊，主要的他这个…啊，他这个辨证的，就在他这个方证上。所以他既辨病形，就是咱们说六经

啊，然后更分析八纲，啊，要分析寒热虚实。这个六经他就是表里阴阳了。那么然后在这一个上，这一种病形，比方说看他是阳明病，我们要…还要分析他寒热虚实的。那么这一个时候，比方说这个潮热，可攻了，应该用那一个方剂？还要辨方证。你比方说这个大、小承气汤，连调胃承气汤都算，拿咱们现在的话说。这就是，啊，下实救阴的法子，嘿！这个咱们常用这个。下实救阴的法子，一个法子而已呀，该用哪一个方剂？现在…后期…后世医书都不到家，唯独他这个书。这个方剂你要不能够纯熟啊，在临床上应用啊，不会治病的。你像光这一个“下热存阴”，好，你随便往里头搁下药，那不行。该用大承气汤用大承气汤，该用小承气汤用小承气汤。所以他这个书，好就还好在这儿，啊。他这个主要的精神，就是方剂适应证，所以咱们叫方证了。我们看看他这大承气汤，大黄、厚朴、枳实、芒硝。这个他没有甘草了，啊。大黄、芒硝搁到一起，这个份量也相当的重的，啊。同时他这个，大量用厚朴、枳实。厚朴、枳实这个药啊，它就是一个行气消胀，啊。那么这个大黄、芒硝再搁行气的药，那一个下…往下攻下的力量那相当的猛峻了，啊。所以咱们说大承气汤能治大实、大满、大痛，啊。他这个…胀的厉害，啊，热的厉害他也疼。所以这一个药量相当的大，这个药剂也相当的猛。所以用这个药的时候啊，总是要慎重。他这个书就讲这个，开始他这个，就反复给大承气汤讲。那么我们现在用这一个量也较比过大，平时我们也不这样。他这一个，这是这个，你像这个大黄，也是四两，啊。芒硝是三合呀。所以上边，这个它是半升，这是肯定的，它是五合，啊。这个三合就是这个，我们这个茶杯就三分之一，那个…那个量。那么那个芒硝这个药啊，它是一个去热，啊，软坚、通便。这个作用主要是这个，它是治热呀。你看有潮热都…都搁芒硝。那么配伍大黄，方才讲它泻下，就够重了；如果再用行气消胀的这种药，那下得更猛了。所以这个厚朴，啊，它半斤，这个药量也相当重了。枳实五枚，这个五枚也就五六钱呐，搁

着现在说。那么大的这个枳实还，还多一点。我们现在用啊，也不要这么重。这个大黄、芒硝啊，就搁个三四钱，顶重也不过就是五六钱，那得是…重病；厚朴、枳实呢，啊，也就是四五钱这么用就可以的。小承气汤，小承气汤差多了。他把芒硝去了，所以它泻下作用不重的，但是厚朴、枳实它也都有，也消胀。后头还有个三物厚朴汤，啊，单独通便消胀，他把厚朴枳实加重了，那治这个胀满为主的。它与这个调胃承气汤来比较啊，调胃承气汤比这个小承气汤这个通便的力量还是强的；但是呢，消胀的力量，小承气汤是比这个调胃承气汤还是重的。

李冠杰：这个条文在《宋本》里是一条，都是第 208 条。但是在《康平本》里边，这是两段条文，一段是顶格排版的条文，一段是降一字格排版的条文。换句话说，是两个不同的作者写的两段文字，再说得重一点，就根本不是一本书上的东西，不是一个作者的嘛。

我们把它分开来解读：

顶格的条文部分，是从“阳明病”一直到“大承气汤主之”这一段。这一段《宋本》把旁注内容篡入正文，所以在语气上和个别字上都和《康平本》有出入，但是这里边没有严格的问题，大家有兴趣可以自己去看一下，有《康平本》跟我们作着标记呢，影响理解是不会的。

“阳明病”，在这儿就是指的阳明里实热证。但在这里，它既有为后边论述的这种病性定性的意思；同时又有表明患者还存在本条文所列举的这些症状之外的某些典型的阳明病症状反应的这一层意思。为什么要作这样的解释呢？许多人受降两字格解释的条文影响，把它简单地理解为：这就一个大便不通。这不够全面，因为大承气汤证甚至还会出现下利的情况。

“脉迟”，本身是一种搏动次数少于常脉的一种脉象，应该算是一种不及的脉象。一般情况下，当人体偏于寒，偏于虚的时候，多出

现这一类的脉象。但是它出现在这儿，却是一种特殊的情况。下边这些可能是咱们第一次做这样的理解，对与不对，大家仁者见仁，智者见智，这是我的理解，很少有人这么解释。阳明病里边为什么会出现迟脉，会出现不及的脉？本身是一个太过的证，太过的病。这是由于人体处于一种严重的阳明里实热的状态下，后边的症状论述得很清楚，不单单人体的津液大伤，而且人体的循环系统也已经没法适应人体这种过分亢奋的病理状态了，一开始的时候他会表现为脉数或脉洪大，但是严重到一定程度，这个循环系统跟不上了，它反倒一下进入了一种抑制的状态，这时候患者就会表现出一种反常的脉象。就像白虎汤证，它本身是个里热证，常见的症状是不恶寒对不对？但是他有时会出现四肢厥逆，甚至厥冷的情况，跟咱们现在讨论的这个实际上是一种情况，机理是一样的。这个不是我们单纯地推理的问题，不是有人感觉我们老是在根据临床统计资料机械地看那些数字？大家不要机械去看那些数字，那些数字都是些事实，是临床事实的一个客观统计，所以它能说明问题，这个地方就用到它了。在临床统计资料当中，大承气汤证确实存在这种现象，大承气汤证表现不及的脉象几率还是很高的，像细脉，弱脉，无力的脉，甚至欲绝的脉，在大承气汤里边都会有，迟脉也有的，都会出现。这就说明了人体患病以后所表现出来的症状反应的复杂性，所以我们不能简单地套用脉诊的所谓的一些的定论，不能这么简单地看。

这么理解这个迟脉有没有道理？看后边条文“虽汗出不恶寒者，其身必重”，“汗出不恶寒”，本身是典型的阳明病的所谓外证了，而这个“其身必重”的病理与“脉迟”是关联的，也是由于这个人体循环系统处于抑制状态而致人周身无力，感觉到有肢重体乏的感觉。所以他在论述这个“汗出不恶寒”的时候，作者特意用了一个“虽”字，表明虽然有“汗出不恶寒”这样典型的阳明病的症状反应，但是同时也表现出了与其病理相反的症状。这是阳明病的一种特殊的表现

形式，千万不要以为还存在其他类型的疾病，而造成误诊。

我们再往下看，顺着这个思路越往下学习，你越会觉得这是一个很重的阳明病。“短气，腹满而喘”这等于说是三个症状了，这三个症状都是阳明里实热证的症状反应，是里实热证发展到了较为严重的程度以后，一方面腹腔里边的食积积滞得很多了，造成腹腔里边，也就是说胃肠的体积比正常情况下要大，它就会挤压肺；另一方面，里热是呈现一种上涌的趋势，就会造成人体呼吸感觉困难，“短气”。“腹满”正是这个原因，因为消化道积滞得严重感觉到腹满。这个时候如果做腹诊的话，他必定会存在腹部的压痛感，甚至是“近之则痛”，他是拒按的。

“有潮热”，指的就是其热如潮了，这也是典型的里实热证的一个症状反应。

“手足戢然汗出”，就是指的手脚连续不断地有汗出，这也是阳明里实热证的症状反应。

我们将这个条文里边所论述的所有症状反应整合在一起，你整体地分析，你就会很清楚地看出，这是一种阳性里实热证非常严重的一种情况。不仅仅因为里实证严重而造成“短气腹满而喘”，而且里热证也非常严重，汗出不恶寒、有潮热，并且“手足濇然汗出”，更为严重的，是由于人体机能过度亢奋致使人体陷于了一种抑制的状态而现“脉迟身重”。这个“脉迟身重”在这个地方应该做这样的理解，就是说阳明证太重了，反倒是会出现一些反常的症状。

针对这种急性重症，条文最后给的治疗方法就是“大承气汤主之”。所以说我们这么理解的话，这个条文用大承气汤是非常贴切的。

旁注的内容：“有潮热者，此外欲解，可攻里也，汗出者，此大便已硬也”。它出现在这个条文里边，虽然我们不能说它是错，但是有失片面。第一，这个注解含有这个条文论述的这种情况，是由表证发展而来的这种意思，但是实际上阳明病并不一定非得是由表证这么

一个阶段才能发展成阳明病，它直接可以得阳明病的。第二呢，它含有这个条文论述的阳明病，必现“大便硬”这么一证，必须会出现大便硬的这么个症状。人家这个原本本意也没这个意思，这实际上是注解的作者他自己的理解。如果仅仅是注解的话，还问题不大，但是到了《宋本》把这个注解又篡入了正文，就会导致读者对于大承气汤证的理解趋于片面。大家再去看看人们脍炙人口常说的大承气汤证那几个典型的症状，实际上有时候就受这样的误导，带有一定的片面性。

这个条文比较重要，我们做一个小结：

阳明病出现脉迟，虽然有汗出不恶寒等典型的阳明病的症状反应，但是患者却会感觉身重，同时伴有短气、腹满而喘，而且有潮热，手足濇然汗出的，为大承气汤主治之证。

我们把大承气汤的方解往前移，因为后边那段条文和这段条文不是一个作者写的，我们就把它分开了。

大承气汤由四味药组成：大黄、厚朴、枳实、芒硝。这个方中的厚朴，枳实，有行气消胀的作用；芒硝有去热、软坚、通便的作用；大黄在这个方剂当中，既能助厚朴、枳实行气消胀，又能加强芒硝去热通便的作用。这个方剂也可以把它看作是调胃承气汤与小承气汤的合方，去掉了有缓急作用的甘草。这四味药合在一起，形成了一个峻猛的泻下方剂，对于里热和里实俱盛的严重的阳明里实热证，非它莫属，离了它攻不下来。

这个方剂中大黄用了四两，折合到今天是 60 克左右，按一两=15.625 克算，但是其中有几个因素是我们值得考虑的：第一个，经方药量的问题不是一个简单的问题，我曾为这一个专题写过一篇专门的文章，在咱们网站里边有，基本上各个方面都涉及到了。我们稍微详细的分析一下，首先值得我们注意的是分温再服，是两次的服用量，相当于一次大黄用量 30 克。其他方剂用这种分析就有点不太恰当，因为它分三次也好，分两次也好，都是一天服进去。但是这个大承气

汤不是，你只要是见到大便通了，后边就不喝了，所以说可以这样来分析。相当于一次大概就是 30 克左右的样子。第二呢，它这大黄要求酒洗，我们现在可以把它用酒泡了，酒洗以后的大黄泻下的力量就有所缓解了。第三，这个大黄要求后下，也就是这个药的煎煮的时间比较短，这样大黄的力量相应来说也会减小。还有第四个方面，当时的中药不像我们今天的饮片都切得那么规范，那个时候的药比较粗糙，可能是一块一块的都比较大，通过煎煮的过程当中溶出的有效成分就比较少一些，这也是一个应该考虑的因素。

在方后注解的最后一句话“得下余勿服”，这是后人加的一个注解内容，但是这个内容可以视为是服用大承气汤的一个原则，就是“中病即止”。而且在经方理论里边，凡属攻下的方剂，大部分都需要遵守这个原则，就是“中病即止”。

下边看临床统计资料当中，大承气汤证的一些具体的方证，在症状方面我们按着出现频率的高低排列，统计到的医案是 572 个医案，数量还是相当多的啊。表现最多的依次为：便秘、腹痛、发热、腹胀满、口渴、谵语、小便短赤或不利、恶心呕吐、汗出、烦躁、神志不清、自利清水或脓血便。这就出现了，这就有下利的问题了。

舌质：主要的就表现为红舌，其次的还有芒刺的，有干缩的，有弄舌，有舌淡，有紫暗的时候。

舌苔：主要表现为黄苔、黑苔、白苔、灰苔。

脉象：大承气汤证的脉象出现过的有 28 种之多。分别有：沉脉、数脉、滑脉、实脉、弦脉、洪脉、大脉、长脉、弱脉、细脉、紧脉、伏脉、缓脉、微脉、绝脉、浮脉、迟脉、结脉、代脉、涩脉、虚脉、有力的脉、无力的脉，应指似有似无的脉、欲绝的脉、小脉、濡脉、止脉，这样 28 种。

大家千万不要把它看成是机械的数字，也不要把它看成，你既然这样的话，我就没必要去看脉象了，因为什么脉都可能出现嘛，就没

必要，不是。我们通过这些数据，要去分析，因为这些数据是客观的，比如脉象，为什么好多人对脉这么着迷，一个是它本身有神秘感；再一个就是脉象有一个很重要的特点，带有客观性。实际上这些统计数字都有他最基本的特征，就是他带有客观性。临床当中出现过的，这是事实，所有的理论都得跟这些东西接轨才行，这是一把尺子。至少可以从这么多的脉象当中，能看出人体患病以后是非常复杂的，不是患了阳明病就会出现洪大而数的那种脉，不一定，那要看具体情况。

大承气汤有治愈机会的现代疾病也是非常多了，有一大类的疾病，比如麻痹性的、粘连性的、蛔虫性的、急性不完全性的、中毒性麻痹性的，这一类的肠梗阻，都有应用大承气汤的机会。包括像阑尾炎、黄疸性肝炎、胆囊炎、胆石症、化脓性胆管炎、胆道蛔虫、急性胰腺炎、慢性胰腺炎急性发作，像幽门梗阻、胃癌、胃溃疡穿孔、胃肠神经官能症、急性胃扩张、急性胃炎合并扩张、胃植物球、急性出血性坏死性胰腺炎、急性阑尾炎、急性菌痢、急性肝炎、淤阻性肝炎、急性大叶性肺炎、成人呼吸窘迫综合征、急性肺水肿、风湿性心脏病、急性脑血管疾病、脑血栓形成、高血压、心肌梗塞、高血脂症、坐骨神经痛、急性肾功能衰竭、慢性肾炎，尿毒症、尿路结石合并感染、乙型脑炎、流行性出血热、破伤风、正副伤寒、精神分裂、鱼胆中毒等等的，甚至包括猩红热、疟疾、麻疹，应用大承气汤的机会的这种病也非常多，其中大家可能注意到了里边就提到了，像菌痢，痢疾、急性痢疾这一类的，怎么说大承气汤一定会表现为大便硬，不一定。当然，这个虽然说有痢疾这种情况，这个痢疾也非常特殊。

通过学习这个条文，我们对中医的脉诊应该有更加深入地、客观地、全面地认识。这个条文里边论述的，脉迟在大承气证当中，按照一般脉诊的理论，应该是反常脉，但是，不仅仅条文当中有这个论述，而且在临床统计资料当中也支持这种结论。反过来我们就应该考虑一个什么问题呀？这个脉诊，我们应该客观地去看它。经方医学，它的

辨证是一个整体的、综合的辨证体系，你必须四诊合参，而且是症状和症状之间都相互佐证，任何一个单独的症状，你都不能简单用来确定疾病的性质跟确定治疗方案。必须通过综合分析以后，才能最后给病人确定一个基本的病理状态，属于哪一类疾病？什么性质的？并且在这个基础上再进一步地、具体地确定治疗方剂。

为什么会这么复杂呢？我在这儿就没法一下把这个复杂性展开了。比如少量的症状，互相之间有矛盾的症状，都要做综合地分析，像这个条文里边论述的身重和脉迟，它是一种病重到一定程度才会出现这种情况，如果放在其他方证里边，出现反差这么大的症状，你也得考虑是不是存在其他类型的疾病。所以说这个问题呀，相对说就比较复杂。

从这个观点再回过头去看看某些辨证方法，去看看流行的一些脉诊，或人人都知道的一些现成的结论，都是值得考虑的，远没有那么简单。比如脏腑辨证是最容易被人们接受的，因为它很客观，它确实常常和现代医学查验结果是相同的，只要是辨得什么器官患了什么样的疾病，理论上就可以用相应的归经的药，再对上寒热虚实，就可以治病了。可是到最后，时效时不效。为什么？因为人得了病，远没有那么简单。

经方的这种辨证，就复杂得多。既有规律性，又有变化性，掌握起来，应该说有一定的难度。

跟大家分享一下我身边出现一个小事，可能会有一定的启示：这段时间我碰到了两个练太极拳的人，一个是我经常去理发的理发店老板的爱人，她练太极拳已经两三年了。每天早上，带着器械，穿着专业的运动服，去练太极拳，可以说是个狂热的爱好者。最近一段时间我去那里理发，和理发师聊天，聊着聊着就聊到了太极拳的问题。我就和他说关于太极拳的一些背景啊，资料啊，等等的说了好多，关于杨露禅怎么去陈家沟怎么偷艺，怎么传出来，练拳应该注意什么，太

极拳讲究丹田气的运行等等，他爱人听这些东西，特别上心，我在那理发，从镜子里就能看到她在后边站着听，听了以后，她说：你说的这些东西哪有啊？我告诉她你去网上查查看看，学就得专业一些。因为她打了这么长时间的太极拳，她就不知道太极拳真正的要点是什么？只是学一些外形的东西，太极拳内功，她一点都不知道，根本没有那个意识，怎么去练丹田气之类的，从来就没练过。我跟她说了以后肯定是上网看了。两个月以后我又去理发，她老公跟我说：我对象现在不练太极拳了。不练了，大家可以想象是怎么回事？她查了那些像陈小旺太极拳大师等相关的讲座什么的，发现这个东西这么难啊，感情还有这么多需要注意的东西，有些东西要需要成年地练啊，她就没有信心了，然后就放弃了。

还有一个，我北京的一个亲戚，快七十岁的人了，比较有个性，他们亲戚之间撮合着在我们这个小县城里买了一个单元楼，也有暖气，北京住累了就到这儿消遣消遣，住一段时间。我去看他，他也是太极拳狂热的爱好者，但是他是另一种性质的，跟我刚才说的那个正好相反。他一开始闹胃病，然后在北京他家楼下，因为他同学太极拳练得挺好，他听人说，练太极拳什么病都能治，就跟着人家去练。结果病治好了以后，一发不可收，练了十来年了。后来，他把他练太极拳的笔记拿出来让我看，我看了以后，感触很深，就是他每次出去练拳，回来以后都会写心得。他的心得就像我们方歌一样的，写成那样，恐怕有的也是抄的，这个都没关系。你看他用心到什么程度啊？他抄的东西，比如说：虚灵顶进，他会把顶进两个字用红笔写上，虚灵两个字用蓝笔。每一篇纸上抄的东西都是类似的。大家想想，他在写的过程当中，一支笔换颜色的话，也要不停地换啊。你就能想象他下了多大的功夫。所以说，他能坚持了十来年。

这两个学太极拳的人，都是两个比较极端的例子。我想咱们学经方，也有这方面的问题。真正说学来学去，好多人为什么学着经方，

后来又转去学习时方了？去搞什么三部六病了，搞体质学了。就是他老觉得，怎么越学越难啊？闹来闹去好像就没有规律了。不是没有规律，要沉下心来，你是功夫没到家。沉下心来，真正地学进去，你就知道这里边有规律。而且，并不是想象得那么难，只是跟其他的医学不是一个体系，那些好多东西在这用不上。你要建立一个经方医学自己的体系。

下面我们再来学习第二段：

第二段是降一字格排版的条文：“若汗出多，微发热恶寒者，外未解也，其热不潮，未可与承气汤；若腹大满，不通者，可与小承气汤。微和胃气，勿令至大泻下”。

这个条文论述了跟阳明病有关的两种情况，我们也可以把它分成两部分，前半部分一直到“未可与承气汤”，这个部分论述的，实际上就是麻杏石甘汤这一类的方证，有“汗出、微发热、恶寒、身无大热”就这一类的症状。多汗没有大热，还有点恶寒，大家不要以为，麻杏石甘汤证是外有表证里有热，所以说不恶寒。事实是麻杏石甘汤证恶寒不是特别重，但不一定没有恶寒。

这段时间，我这有好几个服麻杏石甘汤的病人，有的就感觉怕冷，说明表证的成分比较大，但是“多汗”说明确实是有里热。这里论的是阳明病，所以说这儿的“多汗”，肯定不像桂枝加附子汤证的漏汗那么多汗，跟那个有质的区别，他不是论述那个东西。这是以里热证和表证而且表证比较重的一种情况，是这么一种病理，没有明显地使用承气汤的指征，“未可与承气汤”。上半段论的是这么一种情况。

后半段“若腹大满不通者，与小承气汤。微和胃气，勿令至大泻下”，他论述的是阳性里实证，也有热证，但是以里实证为主。不单单是“腹大满”，而且还大便“不通”。但是从这个论述上看，他没有列举明显的里热证的证候，所以这就说了，只可以“与小承气汤”，来微和胃气。即使是服小承气汤，也有要求，也不能让患者出现大泻

下的这种情况。可见古人治病，非常讲究分寸。有是证用是方，凡是攻下的药全都是“中病即止”。不仅仅是中病即止，而且对病情不重的，在药量上还要控制。

小承气汤由三味药组成：大黄，厚朴，枳实。我们可以看作就是大承气汤去掉芒硝。方中的各种药物的作用跟大承气汤是相同的，去掉了芒硝，所以说小承气汤证的适应证：是阳性里实热证以里实证为主的这种病理状态。

在临床当中，因为饮食不洁再加上本来就有里热造成的食积发热，或者说小儿伤食，老百姓俗称：伤食儿，都有用这个方剂的机会。在整个经方里面，跟小承气汤药物相同的另外还有两首：一个是厚朴三物汤，另外一个就是厚朴大黄汤。药物比例略有变化，但是作用跟小承气汤作用大同小异，差别不是特别大。

在方后注解的最后里面加了一段附注：“初服汤，当更衣，不尔者，尽饮之，若更衣者，勿服之”，实际上也不外乎就是中病即止，这里的“更衣”是指的解大便。

这小承气汤证的临床统计资料比较详实，我给大家稍微说细一点。

这个小承气汤证的症状，在临床统计到了有 55 个医案。其中症状里边表现最多的，是便秘，占到 29 例。但是便秘里边，医案记载当中描述差别也比较大，有的是大便干结，有的是大便不利，有的是大便不爽，这里边就有差别了；有的是大便艰涩，有的是大便不行，这个描述都不太一样，其中就有一个大便不爽，像这个从分寸上就可以把小承气汤证便秘展得比较宽一些。腹胀 27 例，腹痛 27 例，关于腹痛的记载也是有多种多样的。这 27 例腹痛里边，包括有满腹痛，就是整个肚子疼的，右上腹痛，胃脘痛，脐周痛，胸脘痛，但在疼痛的程度和性质上有隐痛，微痛，有按之痛，有痛甚，疼痛，有拒按，有阵发性绞痛，大家看，这个具有立体感。一旦到了这个程度，在心

目当中对腹痛，就有了一种非常形象的概念，而且也说明人体患病以后，这个症状反应是相当复杂的，不能简单化。它本身就不简单，事实上不简单，你要简单的话就容易出问题。发热 17 例，发热也可以分成热盛，高热，大家注意：这有高热，后边条文里边有关于这个的讨论：身热、日晡所潮热等。剩下的症状出现的就是：烦躁，呕恶（就是呕吐恶心），口干渴，食少或不能食，小便短赤，手足厥冷，神昏。这个统计资料的作者搞得非常详细，大便方面还有什么样的记载呢？有下利清水，和夹有结粪，这是一种形式的下利；还有的记录呢，这个有 7 例，出现频率也不低，下利量少如浆。大家看，记录非常得详实，很客观。小承气汤以便秘为主，我们可以把它理解成特殊的便秘。实际上他里有所结，但是却表现成下利。

舌质：主要是红舌，有红舌、绛舌、红绛舌，有带裂纹的舌，有黑舌，有淡舌，这比较少了，主要是红舌比较多。

舌苔：有黄苔、白苔、黑苔、灰苔、棕苔。

脉象：有数脉、沉脉、滑脉、弦脉、细脉、涩脉、缓脉、迟脉，无力的脉，大家看，跟那个大承气汤证的脉象，虽然没有那么详细，但趋势是一样的，都表现为各式各样的。

小承气汤有治疗机会的现代病里边，跟大承气汤的许多疾病是比较相似的，各式各样的肠梗阻。虽然都是肠梗阻，但是这个热没有大承气汤那么重，是以里实为主。包括像一些急性腹膜炎、急性阻塞性胆囊炎、胆道蛔虫、胃溃疡、脑血栓、局限性肠炎、帕金森综合征、肠伤寒、白喉、乙型脑炎、老年神经精神病、痢疾。现代病这里边也有痢疾、痘疹、阑尾炎。所治疗的现代疾病病谱也是比较宽的。

阳明病、潮热、小便微硬者①、可与小承气汤②、不硬者·不

可与之·（209）

注：

1. “小便微硬者”《宋本》作“大便微硬者”。
2. “小承气汤”《宋本》作“大承气汤”。

若不大便六七日、恐有燥屎、欲知之法、少与小承气汤、汤入腹中、转失气者、此有燥屎也、乃可攻之、若不转失气者、此但初头硬、后必溏、不可攻之、攻之必胀满、不能食也、欲饮水者、与水则哕、其后发热者、必大便复硬而少也、以小承气汤和之、不转失气者、慎不可攻也、①（209）

注：《宋本》此处有“小承气汤”四字。

胡希恕：这一段也相当好，啊。阳明病要是发潮热，咱们根据头前儿啊。发潮热 就可攻里也，是吧？但是，必须大便微硬，这才能用大承气汤。在这一个地方啊，我们容易误会，说，不是大承气汤专攻硬便。这个大便硬啊，是用大承气汤的一个火候，全是热实于里这么一种病，那叫阳明病了。那么他这个，大承气汤的应用啊，他必须大便硬才能用，这是用它的一个，啊，这是一个标…标的呀，啊。要是不硬不能用大承气汤。要把这个大承气汤啊，看成一个专攻大便就错了，它治病的。那么大便硬啊，是用它的一个火候，啊。咱们现在说“火候”嘛。那么可是一样这个不大便已经六七天了，究竟实这个大便硬与不硬呢？那么要有这硬的证候，那没问题了。你像上边这一个“手足濇濇然汗出，大便已硬也”，这有这个证候。那么这一段他是说的，假设没有一个明确证候，那么已经六七天不大便，啊，恐怕有燥屎，啊，有这个，硬啊，屎已经硬了，那怎么？得想个办法。“欲知之法”，这一阵儿，你不能贸然来用大承气汤啊，是吧。可以“少与小承气汤”，先给他点小承气汤。这个地方你要注意呀，这也不是随便拿药试验他的病，这也是治疗。这个大、小承气汤疑似之间，应该用小承气汤。这也是治疗啊，这不是随便试验。但是在这个用小承气汤的过程当中，可以能够看出来。如果是大承气汤证，那屎已经成

硬了，与小承气汤，他便也下不来的，啊，但是与人也无害。所以汤入腹中只转矢气而已，转矢气就是咱们说现在出虚恭，放屁那个意思，啊。他下不来东西，那是里头有燥屎。那小承气汤它力量不及呀。“乃可攻之”，这个时候用大承气汤就对了；如果不转矢气，他大便就下来了，下来什么样儿呢？“此但初头硬，后必溏”，他下来是先，啊，干，后头是稀的，这就对了，这用小承气就对了。那么这个样儿的大便，吃完小承气汤之后，那你就不要吃大承气汤了。那么假若你没这么试验，你开始就用大承气汤，就是先“初头硬，后必溏”这一种的内…内在的病情，要吃上大承气汤啊，“必胀满不能食也”，攻伐太过，虚其胃气，那他就是要发虚了，虚胀虚满，就里头发胀气，而不能吃东西了，啊。“欲饮水者”，他由于大承气汤泻下得厉害呀，伤津液也厉害。那么这个时候他想喝水，可是给他水他喝不下去，“则哕”，哕逆，他胃太虚了，所以吃不得大承气汤都。这个既是试之，也是治之，啊。我们在这么一个阶段，我们应该用什么药啊？应该用小承气汤。如果吃小承气汤而转矢气不大便，当然吃大承气汤。他是这个样子。“其后发热者”，那么吃过小承气汤，他是已下初硬后溏的这种大便，潮热也就是好了。可是没…不多久，他又发潮热，这个发热就指着这个潮热说的。“必大便变硬而少也”，这一定大便又硬了，又硬也是初硬后溏的，他意思指着这一个说，而且也少，因为他泻过了，下过了。那么“以小承气汤和之”，当然还是用小承气汤，也没有其它的大便硬的特别证候嘛。如果吃小承气汤转矢气，那这个病是往前进展了，他那大便都硬了，那当然吃大承气，再给他吃大承气汤。如果不转矢气者，慎不可攻也，那你不要冒冒失失再他吃大承气汤了。这一段非常好啊。这就是说是这个大、小承气汤。所以古人用药该慎重非常慎重；可是该放胆你也得放胆。那么非用这个药不可的时候，你要不用也不行。后头就要讲了。这个小承气与大承气汤之用就有这么样子不同，啊。我们在临床上也是一样，这个病疑似这

间，你从轻治不要从重治啊，无论你是，啊，汗、吐、下都是如此的。

李冠杰：这段文字在《宋本》是同一条；但是在《康平本》是两段文字。前边那一段是顶格条文，后边这一段是降一字格条文。

先看第一段：“阳明病，潮热，大便微硬者可与小承气汤”，附注：“不硬者不可与之”。

“可与小承气汤”，在《宋本》是“可与大承气汤”。

解读一下。“可与小承气汤”，《宋本》给改成了“可与大承气汤”。这就是一个比较严重的问题，这个大便微硬的话，应该考虑小承气汤，实际上到不了大承气汤的那种程度。还有另一个问题，在整个《伤寒论》这本书中，顶格条文里边有关小承气汤的论述，只有这一条。如果这一条也是大承气汤的话，那么整个《伤寒论》顶格条文里就没有关于小承气汤的论述。这种可能性不是说一点没有，但是这种可能性不大。这也能佐证这个条文里边所说的承气汤应该是小承气汤，不应该是大承气汤。

做个小结：阳明病，如果出现潮热而且大便微硬的，可用小承气汤治疗。

第二段，在《康平本》里边，是降一字格排版的条文。在《宋本》这个条文的最后，还有“小承气汤”四个字，应该是衍文。

解读一下：这一段内容应该是作者结合自己临床当中应用大小承气汤的体会，对上一段顶格条文所作的补充说明。因为这段文字说得非常的直白。大致意思：上一段顶格条文论述的这种情况，如果持续不大便六七天的话，恐怕是里有食积了，要进一步确诊的话，可以少量的服小承气汤；如果患者服药以后出现矢气（放屁），则说明里实证已经成了，这时候可以用大承气汤攻下；如果服了小承气汤以后，不出现矢气的话，说明里实证还没有达到大承气汤证的程度，这个时候患者的大便常常表现为初头硬后必溏，所以不可用大承气汤攻下。如果误服，会出现腹胀满，不能食。如果患者因为误下而陷于津液虚

则会有“口渴欲饮”的症状；但是，因为是误服大承气汤而致胃的功能比较低下，所以喝了水以后，反倒是会出现想吐的这种情况；此后再出现发热的话，这实际上又出现了里热。必会再度出现大便硬而且量还少，可用小承气汤来治疗。而且最后还叮嘱凡服小承气汤不出现矢气的，千万不要用大承气汤攻下。

从这段文字来看，这肯定是作者亲身的临床体会，写得非常详细，而且也把病理解释得比较清晰。

夫实则谵语、虚则郑声、（注）郑声重语也① • （210）

注：“郑声重语也”《宋本》作“郑声者，重语也”。

直视谵语、喘满者死、下利者亦死、（210）发汗多、若重发汗者、亡其阳、谵语、脉短者死、脉自和者不死、（211）

胡希恕：210条：“夫实则谵语，虚则郑声”。郑声，重语也。直视谵语，喘满者死。下利者也死。这个“谵语”这是我们在临床上，这个里实证啊，经常遭遇的，这在阳明病里头这也是个主要的一个证候，他又拿出来讨论一下子。这个里实，他就要谵语，啊。他所以说“实则谵语”，谵语者就是狂言乱道啊，啊，许有这么说…说胡话。“虚则郑声”，如果人已经虚起来了，正虚，邪实，啊，狂言乱道，那么这个正已经虚了，叫郑声。什么叫“郑声”呢？底下有解释，“郑声者，重语也”，一句话他是没完没了的反复说，叫做…叫做郑声。这个在临床上也可以，啊，要体会。狂言乱道这个不要紧，这是实，这个攻就能好。一句话，小声小气的，是自己默默没完没了，这叫郑声，这一个都是虚，啊。这个虚就成问题了，啊，看可攻不可攻了，要是虚到不可攻这人非死不可。“直视谵语”，他不用说郑声了，就拿这个“谵语”说也有死证。直视，我们讲阳明这个死啊，都是由

于这个津虚到家了。这个直视者，精气不能荣于目，这个目系呀，也都啊，枯燥，他眼球不能动了，叫做直视。直视不能寻嘛，啊。“直视谵语”，里…阳明病里实，既谵语而眼球也不能动了。直视，这说明这个津液，啊，不荣于目了，这…这个有生有死了。“喘满者死”，喘满者这是气脱于上。下利者也死，那么这个时候反到下利了，他本来是热证呀，可虚极而脱，这是津液脱于下，也必死。这个“虚极”呀，他就由阳入阴这一种情况了。所以阳明病本来无死法呀，啊，他实证好治。这就是我们方才说的该谨慎要谨慎，该放胆要放胆。你该给人家…该用大承气也得用，你要到这一个人时候，他谵语，甚至于，啊，后来要到直视，那么发生喘满下利，那大夫给人就误了。这也不行啊。所以当大夫也很不容易，这个东西，啊。所以咱们，这后世犯这个病最大了，遇着热病，啊，拿着这种滋阴祛热，这么瞎调理，调理来调理去，就调理这样了，啊。你该用…该攻是得攻，所以等到他这个邪实正衰，这个时候是无所措手了。你补虚，越补越实，去病，人不胜药了，非死不可。那么到虚脱这个时候他更完了，啊。这是自然就要死了。这在临床上也不少见呐，啊。不过这些年我没见着，以前私人开业的时候常见，他这个时候遇着这个病都住院了，嘿，嘿，嘿！都死到病房的。

211 条：“发汗多，若重发汗者，亡其阳，谵语，脉短者死；脉自和者不死。”啊。这个，这一个是给治死的。“发汗多”，就是，啊，反复发汗者谓之发汗多。“若重发汗”者，就是蛮干，就是大量发汗，重发汗，重发汗，本来不要重发汗，他要给重发汗。那么这两种全是“亡其阳”，这个阳就是津液。在这儿更可看出来，啊。所以他这个书的这个阳啊，不像咱们后世所说这个阳。咱们一说阳，都是热，他说的这个阳是津液。这个发汗最丧失人津液。由于大量津…津液亡失，胃中干，他就要“谵语”，那么这个纯粹是给人治的，啊。“脉短者死”，看那个津液，啊，虚到哪一个份气上。脉短，一般那

个脉呀，啊，上到寸口，下到尺中啊，啊。那么它就剩关上这么一点了叫短，上不及寸，下不及尺。“脉短者”，这是血液津液虚竭之象了，那非死不可。“脉自和者不死”啊，上下脉还匀调，这一个，啊，没虚到家，啊，这一个虽然谰语，这是不要紧的。这一个我遇着这，这一个，这个病我的确遇着…这都是在以前我私人开业的时候。我还记得那个人呢，这一个人是个山东人呐，姓马，很小岁数，20多岁，她是个教员，特意来…来北京找我看病来，那一阵儿我一个学生山东人。她什么病呢？她是糖尿病。来了我给他吃药啊，主要的就用这个这个，啊，白虎增液加人参之类呀，她这个糖尿病很快很快的就，啊，就控制住了，就蛮好了。她这个人非常穷，家穷。她从这个，山东来呀，就到她一个家乡家住了，就我那个学生家。她不知怎么的，后来她感冒了，就是说，那一年，就流感那一年呐，那相当的凶。他就住一个医院了，咱不必说这个医院名了，这是北京很有名一个医院了。她就住医院了。住医院，她这个烧啊，打针不退，啊，那一阵儿就给她，啊…后来怎么办呢？就给他吃阿司匹林呐，ABC 呀，这一种发汗药，一吃烧就退，可是今天退，明天就起来。他还给吃这个，啊…吃发汗药。这一个人呐，就是往复这么治疗，一个多月。后来我这个…啊，跟我学习那个人呐，到医院去看她，看着看着不像了，他就跑我这儿来了。唉呀，他说，这个马…是个女的，女同志，他说她这个坏了。我说怎么滴了？他说她得感冒了，住医院了，我今儿去看她，我看不行了。 这个人也请了旁的大夫。后来他说你给看看去好不好？我说是…这玩意儿，那一阵儿私人开业大夫，到这个大医院去，那受气的呀，那是。我说我不去。他说你去吧，啊，他那个医院呀，他有认识人，他说你给她看看。我说去就去吧。我去了。好，这个人呐，那是骨瘦如柴呀，她那穿那个袜子啊，就像个一个棍儿挑着个袜子似的。那个脚那个肉 都瘦没了，她就是反复发汗嘛。我一看呐，在我以前呐，他也请一个中医，我一看那个方子，是四逆汤，就是附子、

干姜、甘草。也是个老大夫开的。我也没支声儿。后来呀，我就…当时那医院咱也不是给会诊去呀，你开方子那医院也不接受。完了我就跟那个…那个同学就出来了。我说，现在呀，没有治疗了。我说，她那个脉呀，浮而无力，啊，可是虚数无度，快的很，还是…还是烧。我说这个现在呀，就一个法子，我说也不能救其命，我说或者能好一点，我说大量白虎加人参，这个参非搁好参不可，我说起码呀，西洋参要搁一两，那一两西洋参了不得呀，嘿，嘿，嘿！她这个人穷。他…他说她能好吗，准好吗？我说我也不保险，我说现在没旁的法子，只能这么用，啊。大量用人参，大量用石膏。后来他想一想啊，他摇摇头，他说她太穷了，啊，她要不能好了就不必非得治了。这个人很快就死了，这就是给人治死的。就是现在这一种流…这种流感病毒性感冒，全部是…一般，啊，说打个吊针就能好？他不会好的。所以他那个，开始那个热呀，那就是我们常用的，就用小柴胡加石膏是蛮好蛮好的，就不会有这种情形。哎，一发汗，他那个体温当时他是散一散，哎，他好了。明天他就来。你看看古人这个发汗，没有反复发汗的。所以麻黄汤之后表不解，只能用桂枝汤。它桂枝汤解肌呀，它就不是个大发汗药啊。所以这个，这就是，这是纯粹这是给大夫看的，啊，大夫真有这样的。我一到这个医院了，没看着这个病，啊，你私人开业时候什么怪病都能看着，这遇着这个病都到急诊室了。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降一字格排版的条文。

这个注解“郑声，重语也”。在《宋本》是“郑声者，重语也”。

我们解读一下：

这个条文，是作者通过临床观察，总结临床当中的一条实践经验。仅就虚实而言的话，实证多偏于机能亢奋；虚证，是机能偏于低下。所以，虚实证各有各的特征性症状反应。

这个条文论述的是患者说话的语气、语调、声调，用这个来判断虚实。与其说来判断啊，倒不如我们客观地说，虚实证从这一方面常

常表现出来的一些特征。

应该注意的是：并不是只有阳明病的虚实证才会有这一类的症状特点。也不是说，所有的虚证或者实证都有此类的症状，这是比较客观地来分析。《金匱要略》中的百合病，就属于典型的虚证，也常常会有这个条文里边论述的，像“郑声”一类的状况。你看这个想吃又不想吃了，想走又不想走了，就是那个。

其实在临床当中，碰到百合病的话，常常这人，既没有精神、一派虚弱的样子。说话颠三倒四的，重重复复的，就是这一类的。

所以对这一类的条文，就应该客观地来看。用我们今天的论述方式，来表述这个条文要表达的意思的话，倒不妨把它颠倒一下：“凡谵语者多为实证，郑声者则多为虚证”。

所谓的“郑声”，条文后面有注解，一句话重复来重复去的，喃喃自语这一类的。

我们通过学习这个条文，做一个延伸。就是经方的辨证，实质是什么？

经方辨证的实质：就是通过人体患病以后，所表现出来的症状反应，来判断人体所处的病理状态。

大家看，这个条文就是通过这个人说话的语气、语调，和精神方面的一个状态，来强调阳明病当中的虚证和实证有时会表现为这样的特点。反过来，就是以这样的特点，来判断它是不是分别处在虚证和实证下。进而再具体的确定治疗的方剂，这就是经方辨证的一个实质。

但是，一个具体的症状所反映的，只是某种病理状态对于发生这个症状具体的器官所产生的影响。这么说呢，比较抽象，那么我在这儿说一个实例，大家就比较好理解了。比如，以舌质上的齿痕为例。这是我们现在辨证当中观察得比较多的一个，只要看舌象，常常会有这一项；从临床统计资料里边，也常常会表现出这一项来。就是有没有齿痕？那么这个齿痕怎么来的啊？齿痕实际就是体液代谢不良造

成的舌体部分的水肿。所以，凡有齿痕者，说明人体一定存在停饮的问题。但是，在实际辨证的过程当中，有的人同样有停饮，却没有齿痕发生。有的表现为下肢浮肿，有的表现为眼睑浮肿，这些都是由于停饮造成的。可以通过这些症状，来判断人体是不是存在体液代谢不良的问题。如果具体到一个症状，来考察有无停饮的问题的话，问题就不这么简单了。舌诊有齿痕，那肯定就是有停饮。如果没有齿痕，只能说明这个人的舌部没有水肿，这一点是肯定了。但是，这个人体不一定没有体液代谢方面的问题，不一定没有停饮，可能是下肢浮肿，也有可能会表现为小便不利的一些障碍，这些都是有可能的。所以，我常说一个症状不能用来判断疾病的。具体到这儿，只凭舌质上没有齿痕，你不能完全断定他没有停饮证。要如果有齿痕的话，肯定是有停饮，但没有齿痕，你还不能完全断定没有停饮，还要参照其他的症状。比如望诊、脉诊、问诊。所以经方的辨证，要全面、要客观。

这个全面呢，我觉得也应该客观地看，我们不能每一次问诊的时候，把《伤寒论》里边列举的 1800 多个症状，都问一遍，就算是现在一些规范的教学资料里面列举的问诊的项目，你也不可能全部问到。由此可以延伸很多，望诊方面也是这样，也有这方面的特点，特别是脉诊，现在依然有增无减。就是不能客观地去看待。

我记得前几次学习的时候，我曾经说过这一类的问题。其实脉诊无非就是这个人处在这种病理状态下，从循环系统表现出的某些信息。而且这些信息并不是跟那个病理状态是一一对应的，并不是。咱们刚学过的大承气汤证，大承气汤证可能出现 28 种脉象，几乎包括了所有的脉象。这也就是说，在大承气汤证的病理状态下，对循环系统的影响是多种多样的，他表现出来的反应也是多种多样的。不仅仅是脉诊，其他的，也都有同样的规律。不要老盯在一个症状上，比如，你怀疑这个人有停饮的问题，就去看舌质，他如果有齿痕，那没问题了，你还要再进一步地去辨方证；他要没有齿痕，你再去找找他还有

其他的这方面的一些证据没有。按他的脚脖子会不会有浮肿的情况，问问小便，摸摸脉也能起个参考。

下边呢，《宋本》里边第 210 条的后半部分和 211 条，这两条呢，在《康平本》是同一条内容。都是降两字格的。

“直视、谵语、喘满，喘满者死，下利者亦死”。这是第 210 条的内容。下边呢是《宋本》第 211 条的内容：“发汗多，若重发汗者，亡其阳，谵语，脉短者死，脉自和者不死”。

下边来解读一下：

先看“直视、喘满、谵语者死，下利者亦死”。这一段实际上就是对上一条论述的“谵语者”所做的进一步地讨论。

直视：疾病发展到危重程度的时候，所表现出来的一种目光呆滞，眼球都不能晃动了，这一类的症状。

喘满：里实证发展几乎到了最后阶段，人马上要不行了的时候，表现出来的一种呼吸困难、浅促的这么一种状态。正因为这个病这么重，所以这个作者就把它说成，已经不可救药了。

“谵语者死，下利者亦死”。指的同样在这种危重的情况下，出现“谵语”或“下利”的，都是病情非常得严重，预后不好的一种状态。

第 211 条：“发汗多，若重发汗者，亡其阳，谵语，脉短者死，脉自和者不死”。论述的是发汗太过可能出现的不良后果。

“发汗多”，就是发汗本身就过了，又进行“重发汗”。不单单重复，而且发汗的程度肯定是很重的。

“亡其阳”，在这个地方理解成严重的损伤人体的津液。作者的本意含有：亡人体的阳气的这一方面的意思。他本身就有这个意思。

如果理解成亡失人体的阳气，其实也没问题。这个咱们应该分开谈，经方理论很少做那样的论述；像时方的阳虚，阴虚这一类的，这在经方里边一概没有。大家去看经方的原文，特别是顶格条文没这些

论述。这都是后世医家的一些延伸。

“谵语，脉短者死”。因为人体津液损失太严重，致使这个脉上不及寸，下不及尺，脉只有关上那么一点，因为胃中枯竭而发谵语。这样严重的情况，就可能危及生命。

“脉自和者”，“脉自和”说明虽然发汗太过，但是还未达到严重损伤人体内环境的那种程度。人体的津液损失得不是那么厉害，脉象仍然平和。尽管发汗夺了人体津液，但是对人体的循环系统还没有造成明显的实质性的影响。人体还有一点资本。所以这儿说呢，不死。如果经过合理的治疗，人体可能会比较快的恢复了。

伤寒、若吐若下后、不解、不大便五六日以上、至十余日、日晡所发潮热、不恶寒、独语如见鬼状、若剧者、发则不识人、循衣摸床、怵惕而不安、微喘直视、脉弦者生·涩者死·微者但发潮热·谵语者大承气汤主之、（注）若一服利·则止后服·（212）

注：《宋本》此条文如下：

伤寒若吐若下后不解，不大便五六日，上至十余日，日晡所发潮热，不恶寒，独语如见鬼状。若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘直视，脉弦者生，涩者死，微者，但发潮热谵语者，大承气汤主之，若一服利，则止后服。

胡希恕：这个太阳伤寒呐，依法当发汗呐，“若吐若下”这全是误治，一方面丧失津液，二一方面虚其里，邪…外邪它就是陷于里，那就发生阳明病了，啊。不大便已经五六天了，上至十余日，啊，以至于到十余天也不大便，日晡所发潮热……（音频 026 完）（音频 027 始）……这一般的这个老太太都知道。“惕而不安”，无故惊恐而不安宁。“微喘直视”，我们头前儿说了，直视谵语，喘满者死啊。他没到喘满那个时候，微喘，这病也就相当可以了。“直视而微喘”，这气欲上脱而没脱，所以他不到那个死的时候啊。那么这个时候就看

脉吧，“脉弦者生”，弦是有余的脉，弦、弱这两个脉是对待。脉弦者生，说明这一个，这个身体还有抵抗力，啊。他不…还不是一个虚到家，还可以用大承气汤背城一战。“脉涩者死”，涩者，啊，指虚到极了，咱们说这个，啊，血液虚竭之象了，那不能认药了，大承气汤下去就死。你不吃大承气汤他非死不可，就是治也死不治也死，他不胜药了，大承气汤下去，人虚到这个份气上，他对…他对这个药他不认，啊，就是不胜这个药了。你要不是吃大承气汤呢，他这病去不了，所以这个地方非死不可。“但发热谵语者”，这就是回头说“独语如见鬼状”以前这一节儿。只是发热谵语呀，“微者”，轻的话，啊，只是像上边所说这一个，啊，日晡所发潮热，不恶寒，啊，如见鬼状，这一种谵语，这不要紧，那就用大承气汤下之就可以好了。那么这一段的意思啊，就是我方才所说这一个。那么这个该攻你得攻，所以当大夫啊，又要细心，啊，慎重，又要放胆呐。你该攻你得攻，你到这个时候了，这个病人到这个循衣摸床，惕而不安，啊，微喘直视，到这么一个分上，这纯粹给耽误了。这一个耽误，也未必是一个大夫耽误的。你看看有很多呀，啊。现在我想也有啊。啊，遇到这种热病啊，咱们十有八九认为…啊，一见到热就是阴虚，六味地黄啊，这种这个…啊，就上来了。这东西它坑人。顶大了，一看“谵语”了，啊，这是扰乱神明了，这就是…啊…局方啊，局方至宝啊，啊，安宫牛黄就来了，这是看家本领，过去就没招儿了。其实，这个他是内实，这东西都不行啊，都足以害人。这我说这话也是，也是…也许过激一点，但是我是的确看着这么误人的。他这一…这一…这一段书啊，就是这个。所以你该…你不要延误到这么个份儿上。当然这一个也是有误治了。这个误治是最厉害，他本来这个阳明病，它就伤人津液，这一个他由于误吐误下，他根本他治疗上就伤津液，而又把这个外邪引到于里，而发生阳明病，它来了这个势头就是重的。所以这个地方啊，啊。我认为他这…这几大段全是给大夫看的。这么样子治坏人是…

嗯，很不少。这个大承气汤，它每一副都这样子“若一服利，止后服”。这个，这个峻攻的药没有连下用的。这古人也讲这个“服微而愈嘛”。只是你这个药用的恰当，那也不会不好的。而且这个药也没有连下用的。

李冠杰：这是个顶格条文。

这个条文在《宋本》里边稍微跟《康平本》有一点区别，一个是“不大便五六日”后边这个“以”字没有了，大家可以读一读啊，就跟以前不太一样，没有太大的问题。“发则不识人、循衣摸床、怵惕不安”，这个“怵”字《宋本》里面没有，而是“惕而不安”。这个问题也不是说特别大。

下面我们解读一下：

“伤寒，若吐若下后，不解”，伤寒本来是应该以汗解的，若吐若下，都是非法治疗。这里可以与第 58 条做一个相互参照，第 58 条论述的是经过误治，误吐误下之后，这个疾病反而得愈的这么一种情况。而这个地方论述的是误治以后发生了严重变证的情况。为什么提醒大家去对照 58 条？不是说表证误吐误下之后都会好，也是不可能的事。这儿就很明显，跟它治法相似，结果不一样，同样的误治后果是会多种多样的。这儿的“不解”，应该是指仍然存在着某些表证的症状反应，所以说表证还没有解。因为条文的后边还有一个症状，“不恶寒”，所以说这儿即使是有表证也已经非常轻微了，最起码表证里边那个典型的症状反应，“恶寒”没有了。

“不大便五六日以上，至十余日”，这是由于或者吐或者下以后，伤及其里，导致人体出现里实热证，跟刚才的问题是一样的。刚才咱们讨论的是，同样是误治，误吐、误下有时候表证可以好，这个条文论述是没有好，发生了更为严重的病变。具体到这一条里边说的，是又发生了里实热证，实际上也有发生里虚寒证的，但是这个地方因为是阳明篇，发生的是里实热证，而出现的津液虚损，所以说造成的消

化道内食物积滞。

“日晡所发潮热，不恶寒”，这是典型的阳明里实热的症状反应。

“独语如见鬼状”，这是一种神志不清的症状反应。“独语”就是自言自语，自己跟自己说话；“见鬼状”肯定是一种精神昏迷的状态。大家看看这个地方，跟说胡话有点接近，为什么这儿没有用“谵语”？因为这个时候，人体处于里实热证，但是人体本身经过误治以后，已经陷于虚弱的这种状态了，这种状态下有时候就会表现为这么一种症状，跟那个“谵语”有一点区别，像郑声和谵语之间，加上一点神志不清，这么一种状态，要这么细品。实际上经方里边论述相当得详细、非常细致。其实这个地方他要扔给你一句“谵语”也是没有问题的。

“若剧者，发则不识人、循衣摸床、怵惕不安”，是因为阳性里实热证严重而出现的危笃重症。经方理论中许多的条文，你初看它时非常像一个医案的记录，所以有人说《伤寒论》里边张仲景就是记录了很多的临床医案，其实经方理论里，哪一个条文，就是再像一个具体的医案，它也不是记录的一个真正的医案，都不是。都是长期对临床实践经过观察总结的，这是高度浓缩的。但是他表述方式，常常是以具体医案的方式表述出来的，这个条文就是一个很好的例子。

前文当中“若吐若下后”，要把它看成是一个具体的医案的话，就成了一个患者先用了吐法后用了下法，成了这个了，是不是？病因就成了，先吐后下，反复地经过误治。但是你要参照后边这些条文以后，它不是这样。这儿有一句非常能说明问题的三个字“若剧者”，是说严重的，言外之意是不是还有轻微的？肯定有。所以说这就不是一个医案了，这是一大类情况，这个地方讨论的是严重者。这个条文尽管看它，非常像论述给一个人治病的过程，实际上说的是一大类情况。你再回头看看“若吐若下”就好理解了，跟这个患者是用的吐法，跟那个患者是用的下法，要说先吐后下或者说先下后吐也没问题，这

样面就宽了，这种含义就丰富多了。严重者就说“若剧者”，不仅仅要出现“日晡所发潮热，不恶寒”，而且当它发作起来以后，就“发则不识人，循衣摸床，怵惕而不安”，也就是患者处于一种精神不安的状态，不单单是眼前的一些熟人都不认识了，而且两手不由自主地去抚摸搓弄手边能够摸到的一些衣物，甚至还表现出恐惧惊骇不得安的这么一种症状，就比较重了。

“微喘直视谵语者”，这儿的“微喘”跟我们刚才说的“喘满”有点相似，欲脱于上而表现出来的那种急促的呼吸状态；“直视”也是因为人体的津血都虚，以致于不能濡养双目，眼球转动都不灵了，这就比较重了；“谵语者”跟前文当中的“独语如见鬼状”，实际上是同一类的症状，但是这儿里实热证的程度就更重了。对这一类的情况，已经里实热证到了这种程度了，只能用大承气汤急下了。

这儿还有一个问题，“若剧者”其实还有另一层意思，严重到这种程度要用大承气汤急下，如果不到这种程度，你再去看看前边论述的，也得用大承气汤来治疗。所以严重的能到这种程度，没到这种程度的，按照这个标准来判断，只要有充足的证据能够表现为大承气汤证的，也是大承气汤治疗范畴。

这个条文论述的就是阳性表证因为误吐误下而造成严重的阳明里实热证，处于一种比较危重状态的情况。

旁注“脉弦者生、涩者死、微者但发潮热”，纯属无稽之谈，一点依据都没有。我们有理由这样认为，这是这个旁注的作者看了原文以后，他感觉这一类的患者应该有这方面的问题，就说如果出现哪一类的脉会怎么样？如果说解释，特别是现在那些擅长从脉诊上发挥的人，他解释的头头是道。但是，我们前边学过大承气汤证的临床统计资料，那不是些死数据，都是临床当中最客观的数据，所有的理论都最终要跟它接轨，那是一把尺子，你拿尺子来量一量它，马上就能看出来它的长短。这个大承气汤证的统计资料当中，他说的这三种脉象，

一个是弦脉、一个是涩脉、一个是微脉，在大承气汤证里边完全都可以出现。而且这些脉象都有用大承气汤的机会，绝没有“脉弦者生、涩者死、微者但发潮热”这样的规律存在。实际上你从这儿就能看出来，这个作者在学术上就有将脉诊僵化绝对化的倾向，直到今天依然是这样。

条文最后有这么一个小附注，“若一服利，则止后服”，实际上这和大承气汤方后注解的内容是一样的，就是中病即止，这个没有什么深意。

下面对这条做个小结：本为阳性表实证，经涌吐或者泻下的方法治疗之后，不解。患者反而出现了不大便五六日以上，甚至十余日无大便，并且还出现了日晡所发潮热，不恶寒，独语，如见鬼状，那么严重的甚至发则不识人，循衣摸床，怵惕而不安，微喘、直视、谵语的，为大承气汤主治之证。

阳明病、其人多汗、以津液外出、胃中燥、大便必硬、硬则谵语、小承气汤主之、若一服谵语止者、更莫后服^①、（213）

注：“更莫后服”《宋本》作“更莫复服”。

胡希恕：你看这个辨证多细呀！他这一个他不是由…不是由这个…先有热来的，这个人素日就多汗，他得了阳明病啊，他汗还是多。你看这一个他也没说发潮热，他就由于多汗而津液外出，这个身体这个津液往外，那么他胃中它自然就燥了，大便也就硬，硬了就要谵语。所以说只是一个“谵语”就给吃大承气汤这是不对的，你得…所以这个辨证你准得细仔。他这个，由于多汗，大便硬而谵语，那么这个就说阳绝于里呀，就是津液根本就是虚呀。这一个没有用大承气汤的必要。小承气汤主之。这个地方都细微极了。所以我们说这个方证，方剂的适应证，既要掌握他这个证，也要掌握这个情。这一个怎么来的？

他这就由于多汗，他没有那么大的热，啊，当然我们在这个地方里头呀，要…要临床的话呀，我们手也得勤勤，啊。那么你要摁摁他这个肚子。真正的大承气汤证啊，那上不得手啊，一按他是…他怕摁这一个。也是我一个…咱学院一个老朋友陈慎吾啊…死了。他的母亲得痢疾，得痢疾呀，有这么一个两个月，这个痢疾不好。陈慎吾没办法他找我给看去。我一看那老太太呀，好！说胡话，啊，那舌苔那个黄啊、干，我一看就是大承气汤证，我可不敢用啊，这老太太七十多岁了。我让陈慎吾，我说你摁摁肚子，她总是老太太也是女的，女人，我也不好给她摁肚子去，我让他儿子摁。陈慎吾一上手，老太太嗷嗷叫唤。我说没问题，吃大承气汤。她吃这个药啊，她一宿竟拉下干巴巴蛋子，拉到那个盆里头当当三响，啊，完了就好。她是痢疾，那痢疾呀，她…那…一天呐…那…啊，那个下重的很。所以这个治病啊，这东西就是，啊！不能够…当然是…他这个由于寻常出汗多，他绝…里头绝不那么实地厉害了，啊，虽然谗语，啊，这一个大便也不过是初硬后溏啊。那么这个时候你可以摁一摁，摁摁腹，尤其心下这个部位。那么如果实的厉害，他这个…人吃这个东西呀，也停宿胃，他也不消化，他津液亏嘛，啊。那下边就是说“胃中有燥屎”，其实胃中不能有燥屎，他那个食物来那里头燥结了。那你要摁这个心下，他非常疼。那么这一个“其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必硬，硬则谗语”。这一个大便硬而谗语，他就是由于汗出多，啊。那么这一个，当然是不能够大攻破。啊，他没有这个潮热等等那种情况。实质里头也不是那么结实的厉害。这个辨证都够细的呀。所以这地方要留心。你像我们头前儿所说的这一个，啊，发汗多，若重发汗，如果这个没有其它情形只是大便硬而谗语，也遵这个例子，也不能吃大承气汤，那么如果他到后头，脉已经短了，那非死不可了，那你吃，啊，吃这个药也不行，是吧？所以是由于汗多，亡失津液而造成这个大便硬，大承气汤你要慎用、慎重，啊。

李冠杰：这个条文在《康平本》为降一字格排版的条文。

条文当中的“更莫后服”，在《宋本》是“更莫复服”。

下边解读一下：

这个条文和后边的第 214 条，都是降一字格排版的作者根据自己实际临床当中，应用小承气汤的经验，对顶格条文的内容所做的补充。

这个条文论述的，是患者有典型的阳明病的症状反应，但是却是以多汗为主要特征。因为汗多，所以造成消化道内津液虚损，致大便秘。并且因此而引发“谵语”，这类情况，应该用小承气汤来治疗。

虽然从这个条文所列举的“大便秘”、“谵语”等症状来看，非常像里实热俱盛的，既有里实证也有里热证，都非常盛的，有点像大承气汤证。正是因为这个，而特别强调了这是因为汗出太多发生的。主要的原因就是津液虚，津液虚得太厉害了。在这种情况下，病人反映出来的，就跟大承气汤证比较相似。在这一点上，有的学者就认为这个地方不应该是小承气汤证，而应该是大承气汤证。实际上，大家再想得稍微宽一点，去看看麻子仁丸证，互相比一下，就比较容易理解这个条文的意思了。麻子仁丸证的病理就是：津液虚发生里实证，或兼有里热证，但是热证不是主要的，主要就是津液虚而造成的大便秘的这么一种状态。但是，麻子仁丸证有个什么问题在里边？明显的有人体虚的问题。那个方子就是以小承气汤为基础，加了一些增加津液、润肠通便，同时又有补虚作用的药物。

我们回过头来再看看这个条文。这个条文之所以强调“汗出太多”，就是因为汗出多，造成大便秘，甚至出现谵语的情况，这是小承气汤证。不要以为这是个大承气汤证。也给你说个方法，要是觉得不好确定，你也可以先让他服一点小承气汤试一试，要是出现矢气的话，用大承气汤也没关系。

如果换一种说法，这个条文可以作这样的理解，小承气汤证如果是处于津液虚损严重的情况下，也可能发生谵语之类的症状反应。说

得再宽一点，里实证也可以出现谵语多汗的症状。大家看，你若举一反三，就会发现经方里边很多东西都是活的。这些东西一般都是来自临床的，不是杜撰的。你要这么看，你就会发现小承气汤和大承气汤之间有时候非常相似。为什么前边给你说了少服承气汤试一下？还有人说像张仲景这么高的医生不应该有以药试病的这种情况。临床多了你就会知道，因为人患了疾病以后太复杂了，常常有一些病你很难确定。不仅是我们，可能是我们临床水平不高，大家去看看胡老的医案，胡老的医案也有误治的。为什么呀？就是不好辨嘛。都有误治的过程，这都是在所难免的。所以，不能机械地解读经方理论。

条文最后的“若一服谵语止者，更莫后服”，就是中病即止的意思。

阳明病、谵语发潮热、脉滑而疾者、小承气汤主之、（214）

因与承气汤一升、腹中转气者、更服一升、若不转气者、勿更与之、明日又不大便、脉反微涩者，里虚也、为难治、不可更与承气汤也、（214）

胡希恕：“阳明病，谵语发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之。”这是个错的。阳明病谵语发潮热，这是大承气汤证，啊。脉滑而疾，这个疾就是数之甚也，啊。这个脉数有时候主虚，这种虚热证最多。但是脉滑而数，脉滑主实，这是实热之象，是吧？数者为热嘛，数者为虚。你像肺结核那个脉数，虚数无力呀，那到了末期了，那个脉，啊，一摠没了。可是你稍怎么的，脉腾…腾…腾…腾…腾，快的很，那一个是虚。脉滑而数，好，这是实，这是大承气汤证。所以这个小承气汤主之，我认为这是错的。尤其后头，因与承气汤一升，腹中转矢气者，更服一升，若不转矢气者，勿更与之。明日不大便，脉反微

涩者，里虚也，不可更与承气汤。这是不是这一段上的，不知哪一段的，搞这儿来了，啊。所以以下这个更没道理，这么样的实证，啊，吃小承气汤，还能有这个情形啊？不会有的。这个就是阳明病，谵语发潮热，脉滑而实的大承气汤主之。下边这一个都是闲文，不要信这一个了，这一个总是有错的，啊。各家也就是敷衍这么给瞎说。没有这个事儿。他这么实的证，证实、脉实，哪有用小承气汤的。

李冠杰：这条在《宋本》里是一条，但在《康平本》是两个自然段。“小承气汤主之”之前是降一字格排版的条文，之后是降两字格排版的条文。

分别解读一下：

先看第一段：“阳明病，谵语发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之”。这条论述的跟上一条是相同性质的问题，如果仅从字面上解读，可以把它理解成小承气汤证有时也可能出现“谵语发潮热，脉滑而疾”这类的症状。

“脉滑而疾”的“疾”字，在这个地方不是疾病的“疾”，是数脉之甚，就是脉跳得非常快。“滑而疾”，不单单脉滑，而且搏动的次数非常快，是这种脉象。客观地来看，这些症状很明显是阳性里实热证俱盛的，都是些热证，甚至都没有给出大便是什么情况，再加上后边的治疗方剂，这肯定是一个阳性里实热证，实和热都非常盛的病理状态。这儿只能按着字面的意思来理解，如果结合临床应用，像这类条文就只能作参考，或者存疑。因为说的这些症状几乎都是里热证，里实证没有表述，一派里实热的症状，反倒要用祛里实为主的方剂。

所以有的人在解读的时候，直接就把条文改了，这是绝对不可取的方式。大家有兴趣可以去看《伤寒论版本大全》这本书，里边搜集的是八个版本，相对说比较全了，有的版本真是把《伤寒论》改得面目全非了。我们继承古人的东西，不能用这样的态度。我们继承古人的东西就这么一点，首先不要动它，其次在这个基础上再去客观地、

科学地、认真地去分析理解它，去学习它，糟粕就扬弃，精华就继承。如果都随便改，那还有一个标准吗？这还是《伤寒论》吗？如果你认为这个地方应该用调胃承气汤，这没问题，那是你的看法。这个地方从字面上看，是不是这段条文有其他的问题，比如有错简的情况，这个事儿就不好说啦。但是我们从现在所掌握的资料看，它也就是想说这个意思，在小承气汤证上，也可能会出现这类的症状，或许它是有意地专门列出了，既像调胃承气汤又像大承气汤这样的症状，典型症状放在这个地方，就是让你去鉴别，有时候小承气汤也会表现为这类的症状，是不是有这样的意思呢？这种态度可以存疑，以后再详细地研究。

再看看第二段：“因与承气汤一升，腹中转气者，更服一升，若不转气者，勿更与之。明日又不大便，脉反微涩者，里虚也，为难治，不可更与承气汤也”。

这段条文在《康平本》是紧接上边的条文，在《宋本》里就干脆把和上一段条文混为一起了，把它当作同一条了。从这种排版格式上可以看出一个问题，作者的本意是用这段条文对上边的条文做补充说明。所以这段里的承气汤，没说是调胃承气汤、还是大小承气汤，实际就是指的小承气汤，因为它是上一部分的说明嘛！

再来看内容：“因与承气汤一升，腹中转气者，更服一升，若不转气者，勿更与之”。这个作者胆儿真不小，他不单单是临床上瞎胡闹，而且还把他这种东西硬塞到经方典籍里。咱们看第 209 条，那是降一字格排版的条文，它是怎么用小承气汤呢？跟这情况有点相似，那条是在辨大承气汤有一定难度的情况下，为了稳妥起见，用小量的小承气汤来试一下，如果服了小承气汤转矢气了，那么就可以认定是大承气汤证。而这个条文是服了小承气汤，出现腹中转气的时候，让病人再服一升，本身就服了一升小承气汤，如果“腹中转矢气”再服一升，是参照一下整个的经方理论，这都是瞎胡闹，就很不妥啦。

第一点，既然是服小承气汤，而且服了一升，已经服了经方里一次治疗的全量。服了以后腹中转气，说明小承气汤方不对证，这是一个大承气汤证，这就没有再用小承气汤的道理，前边已经给说得很清楚了。

第二点，服小承气汤一升，方与证还不能相应，出现转气，接着让再服一升，这不符合经方的用药规律，经方服药讲究中病即止，像小承气汤这种比较强力的泻下药，就没有中病以后再服的例子。实际上它方证不能相应，出现了不良反应，根本就不能接着再服了，这就是胡闹！

再看看下边，“明日又不大便了，脉反微涩者，里虚也，为难治，不可更与承气汤。”从这一段论述的情况看，这类的患者至少不是转气的那种，就是说服了小承气汤以后，大便通了，后来又不通了，还没把人泻下坏了。通过这么强力的泻下，第二天又不解大便了，实际上是方与证不相应，属于严重的误治。它不仅仅是不大便的问题，有可能造成不良后果。条文中的“为难治”，并不是说这个病难治，而是说前边误治所造成的坏病。不是说虚病就难治，虚证有寒的，按虚寒治呀，虚热就按虚热治呀。本来是一个虚证，按实证治了，能不出坏病嘛？

最后“不可再与承气汤”，说明作者对这类的情况又给过承气汤，而发生了医疗事故，这也是亲身经历。

阳明病、谵语有潮热、反不能食者、胃中必有燥屎五六枚^①、若能食者、但硬耳、宜大承气汤下之、（215）

注：《宋本》此处有一“也”字。

胡希恕：你们一看这就明白了。阳明病，谵语有潮热，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也。若能食者，但硬耳，大承气汤主之。“谵

语有潮热”这里结实了。里有热，热能化食嘛，应当能吃才对嘛。而反不能吃，这怎么个事情呢？这就是啊，不但肠子里头有燥屎，是吧？这个胃里头也有燥屎了，他古人这么看的。其实胃呀，我们方才说了，胃里头不会有屎的，就是食物燥结了，是吧？那么食物燥结有宿食啊，那胃里头有东西，他就不能吃了。所以这个实到…到家了，反不能吃，所以他就这么一个里实，啊。“若能食者”，有热他应该能吃嘛，他也能吃。“但硬耳”，那胃里头没燥屎，啊。那大便可是绝对硬了，大承气汤主之。无论，即是阳明病潮热，谵语发…谵语有潮热，无论能食或不能食，全用大承气汤主之。你看看这一段与上边那一段，你们再对照对照。上边阳明病，潮热，啊，谵语发潮热，脉滑而疾者，反宜小承气汤主之。这哪儿对呀。那么这一段很明白了！阳明病谵语有潮热，无论“反不能食”或者“若能食”，全是大便硬啊。不能食呢，跑到胃里头他也有燥屎了，嗯，大承气汤主之。你要看这一段，这上边这明明白白这是个错误嘛。后头他也有“脉滑当有所去，大承气汤主之”，这个脉滑也是承气汤证啊。所以，这个上边这一段是有问题的，一对照你就可以看得出来。

李冠杰：这是个降两字格排版的条文。

《宋本》当中“必有燥屎五六枚”之后还有一个“也”字，这个没有什么大的问题。

下边我们解读一下：

这个条文论述的，实际上是两种大承气汤证的情况：一种是在有阳性里实热证这种情况下，它以“谵语有潮热”为主要的症状反应，同时伴有“不能食”，后边有治疗方剂，这个“不能食”就是因为里实证非常严重，消化道内的食积已经达到了影响正常饮食，都吃不下去了，都满啦。所以他后头也作了一个病理解释：“胃中必有燥屎五六枚”。这个大家都有一个很客观的认识，他本意也不是想说胃中确实有屎，不是那个意思，而是整个消化道以内，都有食积发生了。“五

六枚”也不过是非常形象的说法，因为像这种情况吃了大承气汤常常会泄有一块一块的大便出来，所以说古人常常在论述上用这种方式，非常形象。但是他本身也不是要表达具体真是那个样，只是用这种形象的论述，来说这个食积已经非常严重了。

另一种，是在阳性里实热证的情况下，仍然“有谵语潮热”为主的这一类症状反应，但是饮食尚可，还能吃，就是大便硬了不通，而且这个“大便硬不通”应该也是比较严重的。这种情况，也属于大承气汤的治疗范畴。

阳明病、下血谵语者、此为热入血室、但头汗出者、刺期门、随其实而泻之，濇然汗出则愈、（216）

胡希恕：有这一段，咱们在太阳篇讲那一个。所以现在把这个热入血室，啊，这就是，啊，瘀血证了。这个凡是出血呀，十有八九是瘀血呀，这个我们也要注意呀。你比方下血呀，衄血等等，都是一个瘀血证多，常常用祛瘀法子可以好的。咱们在太阳篇，这个…啊，是这个血证，咱们现在这个教材都给人改的，弄个什么？啊，太阳腑证。他因为有个瘀…“以太阳随经，瘀热在里故也”，有那么一句话。那么这阳明病你怎么说呢？也能说这是太阳腑证吗？所以他净瞎扯。他这就是人呐，素日有瘀血。哪一个地方有病，哪一个地方虚呀。所以《内经》这一句话还是对的，“邪之所凑，其气必虚”呀。那么他原……他素日有瘀血，这个瘀血大概都是在这个少腹部位多。因为人他是一个…这一个我以前讲过，人他是一个站立的这么一个动物嘛，是吧？他这个液体它就下，所以要有瘀血呀，常常地在这个少腹这个部位，就是盆腔这个地方。那么这一个地方他有…素日潜伏有瘀血，你得了阳明病这个热，进里，哎，这就是《内经》上说，哪一块儿虚，这个邪往哪一块儿去。他这一个就是下血，他就是瘀血证。那么这个

时候你看他身上不出汗，它都往…这个热都…都往这一块来。但是胃里头他还是热的，他是个阳明病嘛。那么对这个病啊，我们可以用这一种祛瘀药，这我治过，啊。那么“但头汗出”，是吧？他这个热不得旁出，它下入血室了嘛。“刺期门”，这跟那个，啊，咱们讲那一个，头前儿太阳篇是一样。这个期门穴，泻这个心下，啊，就是热邪嘛。泻其热，随其实而泻之。虽然热入血室，但是这个热从哪儿入血室啊？还是 阳明病，啊，胃家实。这个还是在上边，所以他说“随其实而泻之”。那么在太阳篇叫“随其实而取之”，啊。那么热去了，里一和，表他就透汗了，出汗了，濺然汗出而解。那么这一个，他不只谗语，这个热入血室啊，甚至于他如狂啊。我治过这么…这个…这一种重证。上面儿我讲那个柴胡剂的时候，我还写…提到这个事儿了。我一个，也是个朋友，他的爱人，她这是这个，得感冒来例假。她那个真是啊，她那个，啊…她那个厉害，她那个来…当时我给她看的时候，她就是十来天了。那就是如见鬼状，她管他丈夫都叫小鬼儿，哈。她…她不认识人了，我给她看呐，她也…看脉她都不让，那她可不能，起不来了，啊。你瞧她脉，她就管你叫鬼，嘿！嘿！嘿！嘿！她那个，后来她…她男人给摁着胳膊，我才能摸摸脉，那就是快的很，脉，还有多少浮。这个病人我还记得挺清楚。姓徐这个人，叫徐秀珍。那一个，那一个事儿也挺巧，当时我闹眼睛，我借一副镜子，是个茶镜，我看完…看完脉了，我就给她开个方子我就回来了。回来我眼镜落那儿了。我吃完午饭了，哎呀！我说我镜子哪儿去了？我一想，落他那儿了。我就赶紧上他家取眼镜儿去。我一进屋子，他那儿熬…煎药呢。我闻那药味儿啊，是一股当归味儿，不是我开那方子，嘿！嘿！嘿！我就心里就明白了。我就问他，我说“你，你煎药呢？”他说，“是，煎药呢。”我说，不是那个药了吧？”他就告诉我了，他说呀，她的姨娘来了，这个人她要死了，啊，你…她北京就他一个姨娘，这是一个亲人，你不告诉她姨娘，这不不好。她姨娘来了，她一说请大

夫没，我说请了朋友，她不愿意了，朋友不花钱呐，是吧？她姨娘又给找个大夫，大概他那药里头是有当归。我闻那个当归味儿挺冲嘛。完了，我就笑了，我说你不信就算了，我说不过这个病啊，我说我挺…我闻着这个味儿啊，这是个补药，我说万补不得呀。我说…我也好说话，我说只能这一个法子，没有旁的法子，我说你信不信由你。我这么说呢，他父亲在里屋，他父亲老头挺明白，就过来了。他说胡大夫这…给我们不是一次看病了，每一次都什么…啊，而且我听他说这话也是，绝对是有理的。得了，把这个药倒了。嘿！嘿！嘿！就把这副药倒了，又把我抓那副药，正好在那个…桌子上搁着呢，他又把这个药又煎了，我就用的那个大柴胡桂枝茯苓丸加石膏。所以这一种病很多，但是那一个是比这个病重了。那么这一个病呢，也是得用祛瘀药较比好。啊…他刺期门也行了，所以这个阳明也有热入血室，这是男人。女人呢，就影响她这…啊，影响她这个月经了，月经一定要是，啊，终止了，血因热而结嘛。所以这个东西他不是膀胱里头的病，哪是膀胱里头的病嘛。就说是太阳腑病，在太阳经，在阳明经他不说了，这回，这是阳明什么病？嘿，嘿，嘿，嘿，嘿！所以这个，这个书呀，尤其读他这个书，总要前后你把他普遍看了，不是这一个病在这儿这么说，到那儿就得那么说了，这不对的。那儿，哪儿对呀。可是咱们现在这个，啊，这个教材，啊，还那么搞呢，那，那，那，的确是有问题，这个东西，啊！

李冠杰：这在《康平本》也是降两字格排版的条文。

我们解读：

“阳明病”，就是指的有阳明病的某些证候。

那么“下血谵语者，此为热入血室”，从他说的这个“热入血室”的病理解释看，这个“下血”主要是指的女性病人而言。既有“下血”，同时又有“谵语”。冠以阳明病，她虽然还有阳明证的某些证候，但是，现在不能视为单纯的阳明病了。应该是阳性里热证与血瘀证同病

的这么一种情况。所以就称作什么？称作“此为热入血室”。

“但头汗出者”，属于里热不能外越的一种反应。反正是有里热、有汗出，或者是汗出多，这个属于比较正常的。那么没有汗出呢？不等于没有里热。最起码里热无法通过汗出的方式来释放，也就是热不得外越。这儿“但头汗出”，就是身上基本没有汗，汗出不畅了。

“刺期门，随其实而泻之，戢然汗出则愈”。上述的这种情况，条文的作者，给出治疗方法，和治疗以后可能出现的结果。这本书当中，有刺期门这种治疗方法的条文呢，一共有五条，都是出自降两字格排版的条文当中。可见啊，这个条文的作者，在临床当中这是他常用的一种方法。那我们现在呢，也做参考吧。

这个条文里边，有个“下血”的问题。通过学习这个条文，做一点延伸。关于“下血”这个证，涉及的面就比较宽。比如：男子便血，妇科的出血，衄血、吐血、咯血这一类的。我们统统都可以称作“下血”。衄血吐血这一类的，在性质上，没有质的区别，只是部位上不太一样。

而造成这一类疾病的病理，都与血证有关。造成这一类疾病的病理比较宽泛。有伴有里热的，还有伴里寒的。从疾病性质上看，阴性证和阳性证都可能出现下血的这种症状。阴性证的黄土汤证；阳性证的下瘀血汤证。虚证的，典型的芎归胶艾汤证；实性的，有抵挡汤证，抵挡丸证。还有别的，这都是个例子。寒性的温经汤证；热性的桃核承气汤证，都是比较典型的。

在临床当中，出血证也是常见的。从出血证里边，咱们引申出来，有因血虚造成出血的，因血瘀也有造成出血的。因血瘀造成出血的这个几率呢，就比较高。在临床当中，血虚血瘀都可能出现出血的情况，而且阴证、阳证、寒证、热证、虚证、实证都有造成出血的可能性。

汗出谵语者、以有燥屎在胃中也、此为风①·须下者、过经乃可下之、下之若早，语言必乱、以表虚里实故也、下之愈·宜大承气汤、（217）伤寒四五日、脉沉而喘满、沉为在里·而反发其汗、津液越出、大便为难、表虚里实、久则谵语、（218）

注：“以有燥屎在胃中也、此为风”《宋本》作“以有燥屎在胃中，此为风也”。

胡希恕：第 217 条：这个他说的太阳中风的汗出呀，他后头有此为风也。所以他这个书这个文字啊，啊，是不好懂。他本来是太阳中风自汗出，在这个太阳病的中间而“谵语”，这个病就是来的猛爆、快，啊。那么在太阳中风这个期间他就并发阳明病，而谵语。这个病不可轻视。你看这个他就，啊，不像头前儿那么，那么个辨法了。那么太阳中风这个病，没有不热的，发热、汗出、恶风、脉缓嘛，啊。那么他这个传里，马上他又谵语，大便就硬，啊，所以这个病不可轻视的。“须下之”，啊，须下之指着用大承气汤。可是一样，“过经乃可下之”。他在太阳病这个中间发生的，得太阳病解之后你才下。“下之若早，语言必乱”，他本来就是谵语，下之若早，啊，使着这个外邪整个内陷，他是，更谵语烦乱了。那么因为“表虚里实故也”，啊。这个…这个病尽入于里，表没病是为虚；病俱在里，里才实。他是这么一个情况。那么言外，表不解呢，先解表，还是先吃桂枝汤啊。那么表解之后，你再用大承气汤。那么我们在临床上也是，这个病有这样的，后头他有这个急下证，啊。伤寒也好，中风也好，那么这个病啊，非常地迅急，啊，猛。那么这一个也不要守常规，赶紧急救。这一个也是这个，这一个他就不像，啊，上边了，啊，这个光谵语，什么就吃大承气…大承气汤呢？啊，他这意思是“此为风也”。他这一句话，即是说明这在太阳中风这个阶段上，太阳中风还没好呢，马上病于里而就谵语。这个二阳并病啊，太阳病，啊，传里并发太…

并发阳明病，一下子就谵语，这个够，够迅速的了。一般他都不这样子，啊，都是先经过这个白虎汤证，啊，口干燥，想喝水呀，汗出地厉害呀。这就是太阳阳明并病，都经过白虎汤证这个阶段。这一个不是，直接就是…，啊，由这一个太阳病直接并发为这个阳明病，他是一个承气汤证候了。这… 这个病不可轻视的，所以他用大承气汤。

第 218 条：“伤寒四五日，脉沉而喘满，沉为在里，而反发其汗，津液越出，大便为难，表虚里实，久则谵语。”上边说的是“太阳中风”，这一个说的“太阳伤寒”。他说“太阳伤寒”也有，啊，在中间，他就是传变为里证的。四五日的时候，脉沉而喘满。沉主里呀，这个“喘满”它不是表证了，啊，纯粹是里实，它压迫这个横膈膜啊，是吧？那么呼吸困难而喘满。“反发其汗”，这一阵儿再发汗是不行了。他脉不浮了，这个表证已经没有了，那么再夺其津液，“大便为难”，那就是，啊，绝对大便就困难了。因汗而表虚，啊，病再夺这个汗，里更实了。所以这是“表虚里实”，久者，没有不发生谵语的。那么这一段他没出治法了，啊，后头他是要有的了。

李冠杰：第 217 条和 218 条，这两条在《康平本》里是同一个段落，那么咱们放在一块儿学习：

在《康平本》里“以有燥屎在胃中也”，《宋本》没有“也”字；旁注“此为风”，在《宋本》是“此为风也”。这个地方把旁注篡入正文的时候，夹在了“以有燥屎在胃中”和“也”之间，形成了这个样子。虽然从字面上看，对原文没有太大的影响，而且把旁注内容也篡入正文里了。凡是真的东西，越推敲它越假不了，从这个地方看，这个条文假设把《宋本》样式的版本，改成《康平本》样式的，谁会想到能在“也”之前，把“此为风”三个字抽出来改成旁注？谁也做不出来。只能是《宋本》在《康平本》的基础上，把旁注篡入正文才合情合理。反过来，没人能做的这样的事，谁能想到这么去改呀？那不是神经上有问题了。

解读一下：

先看第 217 条。为什么分开解读呢？虽然在《康平本》里是一段，但是内容上有比较明显的区别，就把它分开看。因为这个条文在论述上比较特殊，咱们先弄清了它的字面意思，然后再进行分析。

它大致意思是：表现为汗出谵语的，是因为有阳性里实热证而造成消化道内发生食积所致，如果要用下法治疗，应该先观察有无表证存在，如果有表证，要在消失之后才可以用下法。如果存在表证的情况下使用下法，则可能造成语言必乱这样不良的后果，这是因表证和里实证同时存在的原因。如果认为可以下，应该用大承气汤来治疗。

其实这里边基本上也包括一些理解和解释了。条文中有几处必须得弄清的：一个是“过经”，这是一个比较敏感的词汇，这里实际上就是指的表证消失，或者因人体在表证的病理阶段结束之后，就叫做“过经”。绝对跟经络没有关系，无论怎么牵强附会，都跟经络无关。因为后边的条文中有“以表虚里实故也”这样的论述。很明显，这儿的“阳明病”，或者是由表证发展而来的，或者是与表证同时发病，就是同病。这条论述的恰恰是表证还没有消失的时候，要注意的问题。它是先有表证，后有了里证，表证未罢也好，或者是表证和里证同时发病以后，表证仍然存在，没有消失。这种情况一定要等表证消失了，再治疗里证，不遵循这个原则等于是“下之过早”，结果就可能是“语言必乱”。“语言必乱”也只不过是举的一个常见症状而已，不能视为必见证，不是唯一的症状，不能说“下之过早”就肯定会出现语言混乱的情况。

如果结合临床实践理解，这条论述的情况就是患者因为里实热证，已经达到了“汗出谵语”的严重程度，那么会不会有表证存在？接下来就给你说了，要等“过经”以后，表证消失了才可以治疗。是等待它消失，还是用既能清热又能解表的方剂，把表证治得消失了？比如用麻杏石甘汤，或者越婢汤。因为它都有汗出，大青龙汤就没有

应用的机会了，桂枝汤更不能用，因为有里热。所以如果解表，有可能用到麻杏石甘汤和越婢汤这类的方剂。如果是等待它消失的话，它的症状很严重，“汗出谵语”呀，都说胡话了。怎么等待呢？它这儿说得很清楚，肯定是要先治愈表证，然后再用下法，具体的治法这里也没有，是不是治疗也没交代。所以说这条论述的比较特殊。

这一系列的问题都是很现实的，都得紧密地去结合临床。在临床中真要是遇到一个病人，有一点表证，又汗出谵语，应该怎么去处理呢？原则上要先解表后攻里。解表是不是应该先用麻杏石甘汤或者越婢汤，去减缓或者让表证消失呢？如果说应该这样，可条文中这种意味一点都没有。像这些问题都值得再进一步的研究。这个条文论述的实际就是表里同病，里证又需要泻下，前边实际上早就有过论述，在这种情况下要先解表、后攻里，其实就是论述的这个原则。但是，这种论述方法比较特殊，是不是这里有其他原因啊？比如有错简，或者有丢失的东西。反正仅仅从字面上来分析学习的话，总是觉得有一些问题在里边。

旁注：“下之愈”，大家看《康平本》，竖版的最有意思。这个地方做旁注内容的这个人啊，就像一个多嘴的媒婆，有用没用的都瞎唠叨。这个“下之愈”纯属是画蛇添足了。后边有“宜大承气汤”，再给一个“下之愈”有用吗？纯属多余。而且前边的“此为风”，《宋本》里是“此为风也”，就是一个错误的解释。虽然原文里有“表虚里实”的论述，但是，这儿的“表虚”指的是有“汗出”这个症状，还有其他的表证症状而言。要是按旁注作者的理解，现在很多人都这么理解，既有汗出又有表证的，它是表虚证，阳性的表虚证就是太阳中风，太阳中风不就成了中“风”了吗？如果是太阳中风的话，就是桂枝汤类方证，桂枝汤的方证，还有里热谵语呢，已经热得很重的程度了，还要用大承气汤来治呢。这种情况下桂枝汤根本就没有应用的机会。实质上，它这汗出是里热造成的，根本就不是桂枝汤证，也不是

那种表虚证。

这里又涉及到麻杏石甘汤和越婢汤都有“汗出”一证，它们算表实证，还是算表虚证？这种汗出纯属里热造成的，但表实证又到不了大青龙汤的程度，大青龙汤证表实得厉害，既有里热把体液都蒸出来了，但表实又出不来，所以人特难受。麻杏石甘汤证和越婢汤证它表实没到那种程度，所以它有汗出，要把有汗出理解成表虚的话，那麻杏石甘汤把麻黄去了换成桂枝不就行了嘛，那要把人治坏的！这不是一个性质的问题，有质的区别。所以，说它是“此为风”，这就是误解。在这种情况下，温病才出来的，温病派在这种情况下用桂枝汤，到最后得出来的结论“桂枝下咽则死”嘛，因为他不会用桂枝汤，这种情况下绝对不能用桂枝汤。但凡有里热，有多严重的表证，有汗出，也不能用桂枝汤，大家在临床中要时刻记住这一点。都说桂枝汤补中养液，你在有里热的情况下试试，一定会出汗出虚了，越吃病越重。

第 218 条：

伤寒四五日、脉沉而喘满、沉为在里・而反发其汗、津液越出、大便为难、表虚里实、久则谵语、（218）

这条先做字面上的理解，大致的意思是：患太阳表实证已经多天了，疾病进一步发展，而产生了里实证，所以症状表现为“脉沉而喘满”，如果这个时候再给予发汗的话，必会因为“津液越出”而进一步造成大便秘结；此时既有表证又有里实证，而表证呢，也由无汗变为有汗出，如果再得不到合理治疗的话，就必会发展为严重的阳明里实热证而发谵语。

这条论述的是阳性表实证，因为失治而发展为表里同病的情况。因为在条文中，有发汗后出现“大便为难”和“久则谵语”的不良后果。所以，这儿的“脉沉而喘满”应该是阳性里实热证的一种症状反应。如果是因为里虚寒证造成的，发过汗以后，就常常应该出现里虚寒证，甚至出现四逆汤证，就不会出现后边大便又硬结了，时间长了

还会谵语，他就不会出现这种情况。所以说这个“脉沉而喘满”应该是里实热证的。

所以旁注的作者在这儿就加了一句“沉为在里”。

“而反发其汗，津液越出”，这儿是所用的发汗方剂与证不相应，或者这时表证已经消失了再发汗，它才会出现这样的结果。要是按着经方的治疗原则，在表里同病，里证需要泻下，就得先解表后攻里。但所用的解表方剂与症状不能相应的话，这个发汗也不能愈病，只能白白的散失人体津液，又有里热的情况下，里热证就更会加重。

这是一个很重要的事。比方说一个患者，既有表证又有里热证，在这个时候有里热证可能表现为有汗出，要认为是桂枝汤证的话，给他桂枝汤，就有可能出现这条里论述的情况；如果表证是无汗的，是表实证，这个时候用麻黄汤解表，存在里热证也不行，同样会因为人体津液丧失严重，会出现问题。所以说这个地方，如果是真正单纯的里热，有麻杏石甘汤运用的机会，有时候无汗也可以用。该条论述的就是这类情况。

条文中“表虚里实”的表虚，应该是指什么呀？是服了发汗药以后，由以前的没有汗变为有汗了，他就把这界定为表虚了。但是不能因此而理解成，这是由太阳伤寒变成太阳中风了，千万不要那么理解。要那么理解的话，因为有里热，就没有应用桂枝汤的机会。因为这条对发汗前后表证的症状都没有详细的论述，没有举证，而且这个发汗的治疗，又属于方和证可能不相应出现的不良后果。因为资料不是很全，所以我们就没有必要再做进一步的深入探讨了。

三阳合病、腹满身重、难以转侧、口不仁、面垢、谵语、遗尿、发汗、谵语、□□□下之则额上生汗^①、手足逆冷、若自汗出者、白虎汤主之、^②（219）

注：

1. “发汗、谵语、□□□下之则额上生汗”《宋本》作“发汗则谵语，下之则额上生汗”
2. 《宋本》此处有白虎汤方及方后注，此从略。

胡希恕：三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁，而面垢，应该有个“而”字。这个玉函……（音频缺如）……则谵语甚，因为头前儿他有一个“谵语遗尿”嘛，那么后来经过发汗，啊，胃中更燥，他这个谵语更厉害，应该有个“甚”字。“下之则额上生汗，手足逆冷。若自汗出者，白虎汤主之”。这一个合病啊，与这个并病不一样了。这头前儿咱们也讲过了。同时发病者谓之合病。一个病先发，而后转属到旁的病，那么前一个病还存…还有，二一个病就见了，这叫做并病。你像太阳阳明并病吧，由太阳病转属阳明，阳明病也见了，但是太阳病不罢，这就叫做并病。合病就不是了，一发作就是同时来。三阳合病者，就是三阳同时有病，同时发病。虽然这么说呀，但是这一段，他指着下边这证候说的，腹满，谵语，遗尿这是属于阳明了。腹胀满，谵语，遗尿，啊，说胡话，啊，小便失禁，这个小便失禁因热，这一个很多呀，啊。“身重难以转侧”，这个身重的厉害呀，以至于难以转侧，这是，啊，体有湿，这一个应该列于太阳篇，就是湿热这么一种情况。啊，这是在表嘛，应该是太阳病，这是太阳证。“口不仁”，这个不仁呐就是口，口舌干燥，不知五味，吃什么东西啊，不知其味。“面垢”，啊，面垢不是不洗脸，他这脸呐，看着污垢，啊…这一个属于少阳，啊，少阳证。那么这一个表里，半表半里这一种证候，交错互见，啊，所以他叫三阳合病。这一来就是这个病。那么这一个病啊。这是这一个，今后咱们，啊，所说的这一种，温湿这一类的病了。我们头前儿讲了，这一个水火这两个东西，它不同时存在的，这一个咱们讲的阳明病了，主要的还是以阳明为主的。他这阳明啊，他是热盛啊，他就是，啊，消耗人的体液，所以阳明病法多汗。啊，他一方面出汗，一方面小便利。那么那个时候呢，身上他就是，啊，液体相当少了，所以大便干燥，啊。这是我们讲这个，头前那个，

啊，“是为系在太阴”那个已经讲了。那么这一个他是有热，内里有热。内里有热呀，他把这个湿啊，尽量向外排斥，可是排斥到体表，没等他这个大汗出啊，这个阳明病他是蒸蒸，蒸蒸汗出啊。那么他是没到那个地步，啊，所以身上沉，这里头有停湿。那么这一个时候呢，一般这应该用白虎汤。所以他底下“若自汗出者”，啊，已经有汗了，这个“若自汗出”跟上边是一起的，就是腹满身重，难以转侧，口不仁，而面垢，谵语遗尿，自汗出者，白虎汤，啊，这是用白虎汤来主治之。那么这一个病呢，虽然里头热。这个谵语这是一个，胃不和的一个热象了，那么但是他里头没结实，啊。这个“身重”啊，就是里头不结实一个证候。说明身重，湿还存在的嘛，他里头不会结实的。所以这个时候不能吃泻，吃泻药。尤其这个湿，你们看那个，这个…这个…这个《金匱要略》上就有所以湿家下之，啊，湿家没有下法，湿家只是利小便或者发汗，没有下法。要湿家下之，额上出汗，如果小便利，啊，微喘小便利者死，你们看看《金匱要略》上就有，啊，痉湿渴。这个《伤寒论》也有个痉湿喝搁到这个…啊，搁到这里头的。

“若下利”，下利不止者也死，啊。所以这个他也下，这个下他怎么没死啊？他这里头，他是阳明病有里热的关系，啊。但是也不得了，也是“额上生汗”。他不是搁“汗出”，这是“生汗”，这是一个虚阳上浮这个样子。那么究其实那胃真受不了了。他里头不实，那么胃虚，啊，那么水谷不布了，所以，四肢逆冷。他没到那个死候倒是，啊。所以在这个，啊，有表的湿，又有少阳病，少阳病是不可吐下，啊，也不可发汗，是吧？所以这一个，啊，只能用白虎汤，清肃内外之热了。所以他说个，如果…啊，他是“自汗出”，而并不是经过发汗来的了，这是根据头前儿那一个，一系列的证候，应该用白虎汤。这个证也…这一种病也挺多呀。那么后世所说这一个，温病里头，啊，有湿温之类的就属于这一个。那么这一个湿温呐，他不是外头受湿了，纯粹有里热排斥往外来。那么如果，啊，外边出汗出的多，小便也…

啊，也利，逐渐地他这个…啊，身上就不重了，那么就是结实于里了，那个时候可以宜下，啊。那么在这一个热…热一去了，他这个也不往外排，排这个水份了，这个身上也不沉了，也没湿了。所以他主要的这是由于这个内热造成的，还是白虎汤证啊。所以他这个…啊，以白虎汤为主治的，这么一种三阳合病，啊。这个白虎汤咱们头前儿讲了，啊。知母，石膏，甘草，粳米。那么也有对于这一个，啊，有湿的，白虎汤给加苍术，用不着的。他这个知母这个药，就下水。你们看那一个，啊，《神农本草》就有，它就下水，治浮肿。咱们有一个，啊，芍药…桂枝芍药知母汤，那里头就是用这一个来，啊，消这个脚肿的。脚肿如脱嘛。这一个不要搁苍术，他是热，苍术是温性药，不利于人热逼湿在体外，啊。在这个《金匱要略》里头，湿和水气他分两章。这一个湿啊，他不成肿，啊，不过在这个组织里头含湿而已。所以咱们这个风湿相搏，他是骨节疼了，咱们那个湿也看着不着，啊。他要有形…外形了，肿了，就叫水气，归水气，是吧？所以在这个《金匱要略》他分成两个。那么这个湿呢，也有。有，啊，古人又分一个里湿外湿了，啊。究竟实这个外湿啊，是不是从外边受湿，这个是值得，值得考虑的啊。这个我们先不讲那个，遇到机会咱们再讲。那么这一段呢，他是由于内热，啊。这个阳明病，还是主要的还是阳明。阳明病啊，那么在这个热已经炽盛了，但是里头还不燥，外边停湿。所以停湿就因为热，啊。它排斥人的身上体液。那么在有湿这个阶段，那大便绝不，啊，这个胃绝不，绝不实，不到那个，啊，实的这个证候，是不可下的。啊，下之虚其胃，啊，病变百出啊，那么这一个说是额上汗，啊，四肢逆冷，那么这一个就是这个湿，从这个湿上说的。

李冠杰：这在《康平本》是顶格条文。

“三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁，面垢，谵语，遗尿，发汗，谵语”。这儿呢有三个缺字符号；后面是“下之则额上生汗，

手足逆冷，若自汗出者，白虎汤主之”。

在《康平本》里，条文“发汗、谵语”后边的三个缺字符号，在《宋本》就给去掉了，看不出这个地方缺了三个字。在“发汗”之后，加了个“则”字，就成了“发汗则谵语，下之则额上生汗”。这么看，文字是变得非常通顺了，但是真正把原文少的那部分的信息全部给抹杀了，看不出来了。

下边解读一下：

“三阳合病”，指的既有太阳病又有少阳病和阳明病，而且，这三种类型的疾病同时发作，就叫“三阳合病”。

那么看看具体的症状：“腹满身重、难以转侧、谵语、遗尿”，再包括后边的“手足逆冷，若自汗出者”。都是阳性里热证典型的症状反应。

这儿的“腹满”，因为整个这个条文里边，论述的其他的证和治疗方剂，看不到有实热证的证候。所以说，这个“腹满”，应该是里热所造成的“腹满”。

“身重、难以转侧”，有两个方面的原因：一方面，是里热比较严重，迫使体液外出，同时呢，又有“遗尿”。这个“遗尿”应该包含有小便失禁这一类的情况，比频数还要厉害。所以，一般情况下汗出就会比较少，甚至没有汗出。那么这个时候里热迫使体液往外出，通过小便走一部分，因为小便频数得厉害，又不得汗出，就会出现体表停饮的情况，他就会反应“身重”。第二方面，里热过盛也使这个人体处于一种抑制状态，那么人自我感觉周身无力，更感觉“身重”，这就“难以转侧”。

后边的“手足逆冷”可以佐证这一点。因为他是阳性病，常常表现一种亢奋的状态，到了严重的程度，也会出现陷于一种抑制的状态。

“手足逆冷”就是一个例子，就是一个佐证。

“谵语、遗尿”，都是由于里热严重而造成的这种症状。这就是

有里热的重证。

“若自汗出者”，“若”字，在这个地方，应该理解成“或”字，这个“汗出”是一个或然证。本来应该汗出不太畅的，因为他小便频数，但是人体患病以后是复杂的，里热严重了以后，他一边小便比较通畅，一边或者也会汗出。上边这些状况都是典型的阳明里热的症状反应。

“口不仁、面垢”，我们把他界定为少阳病的症状反应。“口不仁”，恐怕到不了口苦程度，只是口中没有滋味，严重的五味不知。

“面垢”，指的是面部污秽，如同蒙着尘垢一样，洗之不去的一种状态。这都是些字面上的解释，或者是纸上谈兵，很抽象。

我跟大家说一个具体的医案，大家好理解。一个快 50 岁的男人，他的脸上比女人脸上长的色斑面积还要大。他脸色本身就黑，他是一块一块皮肤颜色发深，而且边缘还清晰。通过四诊以后，发现就是小柴胡汤证，他胆囊炎十几年了，就给他喝小柴胡汤。他喝了三天，他就说，我喝了以后浑身都轻松。大概七八天的样子，好多的症状就去个七八成。脸色开始慢慢的干净了，大概两三个月吧，脸上一点斑也没有了。那脸让人看着就是一种污秽，不仅仅是污秽，脸上像是色斑的那种样子，一大片一大片的。

这个条文述证当中，没有明显的太阳病的症状。那么太阳病在哪呢？其实太阳病的症状隐含在“三阳合病”当中，这冠以“三阳合病”嘛。或许病人除了上边的症状以外，还有轻微的表证存在。

我们现在常见的，鼻塞，流涕，有点发热，这不都是太阳病的症状吗。

下边“发汗、谵语”，三个缺字符，“下之则额上生汗”，这句话是列举的误治，前头说的这几种情况，要是误治的话，可能出现不良后果。按照常理，这一段文字应该放在“白虎汤主之”之后，比较合理。但是，这个条文特意把这一段文字放在现在的位置上，另有含

义。什么含义啊？

第一个，警示这一类情况不可发汗。既不可发汗又不可下，这是一层意思。

第二个意思，示意读者，即使是经过这样的治疗之后，如果疾病没有发生质的变化。只是出现了“四肢逆冷”，或者“汗出”这个情况的话，依然要用白虎汤来治。有后边的误治和这些症状，用白虎汤来治。没有误治，也没有“四肢逆冷”或“汗出”，也需用白虎汤来治。

这个条文虽然冠以“三阳合病”，但是，这三种疾病所占的比例是不同的，从症状上完全能够看出来。其中表证的反应，肯定比较轻微，从治疗方剂就能看出来。所以在条文里边根本就没有列举，没有论述。阳性半表半里证的反应，也只是“口不仁、面垢”而已。并且这两个症状不是典型的少阳证的反应，所以少阳病的成分也非常轻微。但是阳性里热证的反应却非常得多，而且也非常得重。按照一般的治疗原则，三阳合病应该取少阳治之。但是这儿，少阳病和太阳病所占的比重非常得小，而且白虎汤也不是泻下剂，是清热剂。所以这个条文示人以什么呀？经方的治疗原则也是要视具体情况，有所变化的。就示人这么一个道理。并且阐明了白虎汤属于清热剂。

我们进一步地想一下，这个度的问题也相当重要。假设这个患者要存在口苦，胸胁苦满等症状的话，那肯定不是用白虎汤能解决得了的，在治疗当中也不能仅仅用白虎汤治。所以，只有真正理解了，再去品味这些，几乎跟临床都是丝丝入扣的，也非常严谨。

做个小结：三阳合病，其症状表现为难以转侧，口不仁面垢，谵语遗尿，此时如果发汗，可能谵语，如果泻下，则可能额上生汗，患者同时还有手足逆冷或者自汗出的，为白虎汤主治之证。

二阳并病、大阳证罢、但发潮热、手足𦞑𦞑汗出、大便难而谵语者、下之则愈、宜大承气汤、（220）

胡希恕：那么这个讲的并病了。二阳并病，就是太阳与阳明并病。那么 有太阳病不罢，我们还要先解表，啊。这个头前儿也都有，他就不讲了。他是简言之， 准得太阳证罢，啊，没有表证了，“但发潮热”，咱们头前儿不讲那一个阳明病脉迟嘛，那么准得发潮热。这才说，表…啊，才解了，才可以宜下，可攻里也。那么这可攻里也，要大承气汤还不行的；手足𦞑𦞑汗出，身上当然出汗了，手足也是，啊，不断汗出，这 是大便成硬的一个证候，尤其谵语，潮热而谵语也是大便硬，头前儿也都有了。那么这一个大便成硬的证候这十分充足了，所以净管与大承气汤下之，啊。

李冠杰：在《康平本》里边，这是一个顶格条文。

“二阳并病”，这是指太阳病和阳明病并病。这就是说初得的是太阳病，而后又发生了阳明病，而且太阳病仍然存在的时候，这是二阳并病。但是这个条文里，他论述的是什么呢？实际是在这之后，阳明病又加重了，太阳病消失了，实际上论述的是这么一种情况。那么前边是说，用病因的方式来跟大家展示一下这个疾病的发展规律。

那么“太阳证罢”，这个条文里边有两层意思啊：一是阐明了这个患者刻下他所处的病理状态，就是说，太阳病已经消失了，现在仅余下的有阳明病，这是一层意思。第二层意思就是强调，只有在太阳病消失之后，才可以用泻下方剂治疗的原则。

“但发潮热，手足𦞑𦞑汗出，大便难而谵语者”，这个“但”字，指的是“但”字之后的所有症状反应，不仅仅指的发潮热，后边的症状都包括在内了。

“发潮热”，是典型的阳明病的症状反应；“手足𦞑𦞑汗出”，指的是手脚微微有汗出的一种症状，这也是阳性里实热证的一种症状反应；“大便难而谵语”，说明里实证已经发展到非常严重的状态，

再加上前边论述的这些症状，可以断定这是大承气汤证，没有问题了。

这个条文论述的实际上是什么？是由太阳病发展为太阳阳明并病，而后转变到阳明病，发展为大承气汤证的这么一种情况。

虽然临床当中，并不是所有的大承气汤证都是沿着这么一种路径发展而来的。但是，这个条文却是以这种常见的疾病发展方式，来向读者揭示疾病的一种发展趋势。凡是疾病趋于恶化，常常是由浅入深，由表及里这么一条规律。

做个小结：太阳与阳明并病，因病情进一步加重，太阳病证消失，患者仅现阳明病的症状反应，具体表现为发热，手足皃皃汗出，大便难而谵语的，为大承气汤主治之证。

阳明病、脉浮而紧、咽燥口苦、腹满而喘、发热汗出、不恶寒反恶热、身重、若发汗则躁、心愤愤反谵语、若加温针、必怵惕烦躁不得眠、若下之则胃中空虚、客气动膈心中懊憹、舌上胎者、栀子豉汤主之、^①（221）若渴欲饮水、口干舌燥者、白虎加人参汤主之、^②（222）若渴欲饮水、脉浮发热·小便不利者，猪苓汤主之、^③（223）

注：

1. 《宋本》此处有栀子豉汤方及方后注，此从略。
2. 《宋本》此处有白虎加人参汤方及方后注，此从略。
3. 《宋本》此处有猪苓汤方及方后注，此从略。

胡希恕：“阳明病，脉浮而紧，咽燥口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热，身重。若发汗则躁，心愤愤反谵语。若加温针，必怵惕，烦躁不得眠。若下之，则胃中空虚，客气动膈，心中懊憹，舌上

胎者，梔子豉汤主之。”这一节儿你们看看，跟头前儿那个“阳明病脉迟”是一样，开始。“脉浮而紧”，啊，这是太阳伤寒脉呀。“咽燥口苦”这是少阳，少阳证啊。“腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热”，啊，这一系列这都是阳明病。那么“身重”呢，说明身上还有湿。那么这个也是三阳合病了。不过他着重在阳明病。所以，他这一个他不说三阳合病了，啊，他说个阳明病。因其这个阳明病的证候特别明显了。尤其外证，啊，发热汗出，不恶寒反恶热，那么这个也是三阳合病。你看看这一个阶段上不能吃泻药，不能够用承气汤。头前儿那一节儿，我看看呐，你们看一看更好，啊。 学生：208。 胡老：啊。208，“阳明病，脉迟，虽汗出不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘”，那么这一段呐，是不可吃大承气…不但大承气汤，承气汤也不可以用。所以他搁个“虽”字啊，虽然汗出不恶寒，啊，这是阳明病的证候已显了。但是这一个时候他“其身必重，短气，腹满而喘”，这个言外就是不能吃泻…不能够下。你看看这一段，你前后对照你看一看，你看这一段呐，也有“腹满而喘，汗出不恶寒、身重”，啊，腹满而喘，他就差个短气，腹满而喘里头就包含着短气了，“喘”他就是“短气”嘛。所以在这一个，这纯粹是…他…啊，内热是有了，但是身还有湿，这一个湿不过轻了，不像上边这个三阳合病这一个湿，三阳合病这个湿啊“身重难以转侧”，啊，那个沉地厉害，这一个只是“身重”而已，他就…啊，还搁到最后了，啊，这个湿比较少。所以阳明病偏多，所以他叫阳明病，他不叫三阳合病。那么，这一个，啊。但是他没…既要身重，啊，就不能够吃泻药，啊，他那个说明，那里头，还没成实，啊。那么这个时候发汗行不行呢？更不行了。他内…里热不能够发汗呐，啊，“若发汗则燥”。那一发汗呐，再夺其津液，热更盛，啊。“心愤愤”，这个愤愤呀！就是闷、乱。咱们说人昏愤，就这个愤呀，昏乱，啊，说…糊涂。那么就这热攻冲头脑了。“反谵语”，啊，这就是胃不和的一个倾向了。这个时候你们看看用

什么药？啊。这一个谗语，啊，心愤愤这一个，这一个情形，有用承气汤的机会，但是他没说。那么开始呢，“阳明病脉浮而紧，咽燥口若，腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热，身重”。这一个呢，那么正可以用白虎汤，那是没问题的，跟头前儿这个三阳合病是一样，虽然偏于阳明，但是里不…里，啊，这个胃并不…并没达到胃家实那么个证候。所以这一个时候只能够…还是清肃内外之热了，而且脉还浮。那么经过吃发汗药，所以阳明病就怕津液…他本来津液就是要…啊，啊…就是有一些不守之样了，啊，他是蒸蒸汗出啊，那么最怕发汗，一发汗再夺其津液，马上里头就干，所以一发汗则“躁”。这个躁和烦还是不一样啊，这个烦呢，是热；这个躁，是乱，啊。所以这一个，我们在这个三阴篇上，这个躁是不好的现象啊，啊。躁则扰啊，乱。那么就言其这个，内里头这一个，啊，胃中干，胃气不和的这一个情形是较比…不是光 烦热而已了。所以他“心愤愤”，人也闷乱、糊涂，说胡话，啊。那么这一个时候有用承气汤的机会，但是不要用…不一定得用大承气汤。所以他也没说，你像调胃承气汤啊，小承气 汤啊，啊，或者小量用都可以的。因为这一个，啊，他这一篇他着重在下，啊，这个发 汗，任何人到这个时候也不会用发汗药的了，是吧？所以他没把它明点出来。若加烧针，这也是不可能的事儿，啊。那么烧针逼取大汗，比这个发汗还厉害了。“必怵惕，烦躁不得眠”，啊，“怵惕”就惊恐啊，啊。这个头前儿也有。咱们说桂枝去芍药，啊，加蜀漆龙骨牡蛎呀，或者桂枝甘草汤加龙骨牡蛎呀，啊，用这一类方剂治这个惊狂了，所以这个热，以火济热他更热了。那这个他也没提，因为呢，在这一个情形之下，啊，头前儿既有，他在这儿，他着重这个下，因为阳明病都着重下，那么这个时候不可以用泻药的。所以“若下之”，啊，他胃不实啊，啊，所以“胃中空虚”，空，什么都没有呀，啊。由于泻药而使之虚。那么“邪之所凑其气必虚”呀，胃虚了这个客邪之气它都往这块儿来。所以“客气动膈”，啊。客气动膈就

指着，啊，客热邪气呀，动这个胸膈，啊，所以他“心中懊恼”。“舌上胎者”，舌上也有，啊，大概这一类的都是白苔了。“栀子豉汤主之”，啊，这赶紧用栀子豉汤治其虚烦。他这个…啊，胃里头没有实。胃中不实，啊，这就说这个，啊，发汗吐下后，啊，虚烦的证候，那么所以他下不得的。一下他变成，啊，遗热不…不去，但是胃还虚了，所以他发生虚烦的这种这个，心中懊恼这种证候。那么这个病变呢，他连下举三个，底下这两段呐，全是这一段。《医宗金鉴》呐，把它搁到一起了，还是对的。这个书呢，它都分开了，分开也行。

“若渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之。”这都是指着下之后。这个阳明病是需要下的。但是呢，啊，这就从反面教人了。但是下得，啊，误下了，危害挺多，这个变证也挺复杂。“若渴欲饮水，口干舌燥者”，本来是白虎汤证。白虎汤证啊，他不那么渴，只是口舌干燥而已。由于这个下伤津液，那么他才渴欲饮水，当然也有口干舌燥了，啊，所以这个时候只用白虎汤不行了，必须加人参，啊，健胃滋液。这个咱们也讲过这个方剂，就是用白虎汤加人参。这是第二段。这都是在这个下后，啊，造成的这种这个变证。

“若脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。”他这一个，头前儿不也有那么一段嘛，所以小便不利内有停水，啊，那么忽然间呢，啊，这个人呐，这个阳明病，啊，初愈时，有那么一段，我记得，啊。他伶俐的，本来他是太阳…太阳病，里有停水，表不解的这么一种病。那么可是这个，啊，胃气强，谷气盛也能祛水的。他后世说这一个，啊，阳…这个胃属土啊，土能制水呀，可是这个不应该下，你下，胃虚了它就不能制水了，是不是？那么这一段就是这样子，吃泻药，那么这个变证他给你举那么三个，头一个是个虚烦；第二个，啊，伤了津液了，啊，那么口中干而欲饮，啊，这所以他白虎加人参，本来是白虎汤证；第三个由于虚其胃而使小便不利，小便不利，内里头停水影响表热、外热，外有郁热，所以脉浮发热。那么有了停水

了，小便不利，咱们说这个水不化气了，人烦渴，跟五苓散那个渴是一样。小便不利这个废水排不出去呀，这个新水呢，他就不吸收，啊，不吸收这个组织上还缺少水，缺少水呢，他反应到人的这个…啊，他就觉渴。所以这一种渴呀，他是小便不利造成的。那么这样子呢，必须用猪苓汤，啊，以利小便。可是这个猪苓汤之用，与这个五苓散来这儿呀，啊，因为药物不同啊，可以分析一下。这个五苓散治气上冲，这个因为有桂枝了，啊。所以他有头晕，啊，心悸，这个五苓散证啊。头晕它是什么？他是胃有停水，胃停水多。而且他又有苍术，嗯，他是这个，啊，偏于有表证。那么这猪苓汤就不是了。猪苓汤这几个药啊，都是一个寒性利尿药。一方面利小便，一方面解热。他不治气上冲，他这个水不在上头，没有上头，啊。所以我们用这个猪苓汤啊，全是在这一个，啊，由于小便不利而有这一种，肿，肿的发炎症时候用这一个是最好使。尤其咱们这个泌尿系感染，就用这个猪苓汤加生薏仁，啊，如果这个人呐，大便也稍干一点，少加大黄。这个大黄啊，不要过一钱，现在说就3克了。因为这个大黄这个药啊，重用它通大便，你要少用它就走前阴，它不泻。一般就是用猪苓汤搁生薏仁就行。这个生薏仁啊，要搁就得重用。所以这个猪苓汤治这个，啊，淋病啊，啊，泌尿系感染呐，那个…在急性的这个肾盂肾炎的时候都好使，可得加味，啊，加薏苡仁啊，赤小豆都行。薏苡仁好。他小便一利，渴也不渴了，啊，他热也解了。但是这个治渴的这个一样利尿药，这里头有猪苓，猪苓这个药它解渴，它利尿之中起解渴作用。五苓散这个也有猪苓。那么其它的这个呢？啊，他把桂枝换成这个滑石了。这个滑石也是个寒性利尿药。那么他把这个，啊，以…不用这个苍术，不用桂枝，另加阿胶。阿胶这个药啊，它是个养血的，它止血嘛。那么由于热所伤，啊，这个阴分，它也好。所以有小便走血的时候，这个药…这个药也有时候可用的。这个方子也常用的。

李冠杰：第221条和222条、223条，在《康平本》里是同一段

内容。我们放到一块儿学习，它们之间也是有联系的。

这条在《康平本》里是顶格排版的条文。在《宋本》里这一整段条文分成了三段，分别是 221、222 和 223 条。在《宋本》每一条后边都附有相应的方剂和方后注解，《康平本》里没有。

我们解读一下：

这一段条文论述的是以阳明病为主的一种比较复杂的疾病状态，以及这种疾病容易出现的误治方法、所产生的不良后果和相应的治疗方剂。初看好像是三个独立的方证，但在《康平本》中把它写成一段，实际上这是一段内容，这些方证之间都存在着密切的内在联系。在以前没有《康平本》做参照，现在有了《康平本》了，我们也证实了《康平本》的真实性，所以我们就应该按照《康平本》的结构整体地来解读这段条文。

先来解读第 221 条这一部分：

“阳明病”，在条文中强调阳明病这种病理状态为主，看下边症状就知道了。为什么这么说呢？因为在其它的条文中，有的冠以阳明病，实际上根本就不是阳明病，患者可能某种脉象、症状有点像阳明病，就把它冠以阳明病了，但是根本就不是阳明病。这个地方虽然也冠以阳明病，但是就有强调本条文论述的这些东西、症状、病理状态是以阳明病为主的意思。如果细分，后边分析症状的时候就有了。虽然说这个条文不仅仅是阳明病，但却是一种以阳明里热证为主要病理状态的。

“脉浮而紧”，在中医里常常有以脉定证的倾向，一般情况下常常认为这是典型的阳性表实证的脉象。但是在这条中应该客观地看：第一，从条文论述的这些症状上来看，虽然不能完全排除存在表证的可能，但是表证的分量非常小；第二，因为里热比较严重，从病理上来说，里热将人体的水份迫于体表，血管里的体液比较充实，也会表现为浮而紧的脉，当然也会表现为洪大脉或者说浮而大的脉（差不多

就是洪大脉了啊），这个地方也不排除阳明病中会表现为这种脉；第三，这个脉象同时还暗示了条文后边所论述的有误汗的误治方法，也暗示了误汗的原因之一。结合临床实践可以怎么理解呢？就是说阳性里热证，也可能出现“浮而紧”的脉象。

接下来是“咽燥、口苦”，这是少阳病的症状反应。“咽燥”就是少阳病中的“口苦、咽干”跟阳明病的里热证合并到一起的时候，就会表现出类似的症状。“咽燥”，实际上也可以理解成“咽干”的重症，它不仅仅是少阳病的一个因素，里边实际上有阳明病的因素存在，所以咽干的程度就严重得多。

“腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热”。这些症状都是阳性里热证的症状反应，在条文的后边有“若下之则胃中空虚”，它能证明“腹满而喘”中的“腹满”不是因里实证而造成的，而是因为由于里虚热而造成的，是一种虚热证的反应，而不是里实证的反应。如果是里实证的反应，下之那是正对症，就不会出现“下之胃中空虚”了。这个“喘”当然也是因为里热而致了，前边讨论过很多次了。

“身重”，与“脉浮而紧”在病理上有内在的联系，因为里热重而将体液迫于体表，虽然后边有汗出的症状，但必定是汗出不畅的一种汗出，不会是大汗淋漓、或者汗出量比较大。如果汗出的量比较大，体表就不会有那么严重的停饮，脉象也不一定表现为这样的脉。正因为体表停饮比较多，表现的脉象就是“浮而紧”，患者自身也会感觉到有“身重”的感觉。我认为，患者处于一种比较虚的状态，体能不足也可能会感觉到。从上面这些论述来看，虽然不能完全排除少阳病和太阳病的成分，但是这两种类型的疾病所占的份量非常少，主要的还是阳明里热证，而且偏于里虚，绝无里实证。后边条文里有经过误治以后出现的变证以及治疗这些变证的方剂，也能证明这一点。从第222条看，它本来应该是一个白虎汤证，但是这个症状表现比较复杂，在临床辨证中有一定的难度，常常会出现误诊的情况。下边就列举了

三种常见的误诊情况，并给出了解决的办法。

下边“若发汗则躁、心愤愤反谵语”，就是说上边“身重”以前所列举的那些症状，人体虽然存在较重的里热证，但是因为有“脉浮而紧、发热汗出”这样的症状，在临床中由于医者的水平问题，容易被诊断为表证而误施以发汗的方法，如果医者偏重于看脉象的话，就有可能用麻黄汤之类的方剂，要如果侧重于看证的话，就会把目光集中在发热汗出上，可能会认为这是一个桂枝汤类的方证。不管是用哪一种，在这种状态下发汗都属于误治，其结果就徒伤人体津液，人体本来就有汗出，发汗之后人体津液损失就会比较重，这个时候因为里热会进一步地加重，烦躁的程度也会比以前严重一些。

“心愤愤”是指的心中烦乱不能自主的一种症状，这是一种既热又虚的症状，实际上就是栀子豉汤证中的一个重症，而且里热也重。古人在用字上是比较讲究的，所以要把它与“心中懊憹”区分开来。

“反谵语”中的“反”字，在条文中有很重要的意义。有人在学习的时候要改成“而”字，那既没有根据，也是不对的，咱们学习完了大家就知道了。一般情况下凡是出现“谵语”的时候，大部分都是里实热证比较多。即便是调胃承气汤证，虽然它没有严重的里实证，但也不应该有里虚证的。“反”字正是在强调这个时候的“谵语”本来不应该出现，因为人太虚了、热太重了，所以才出现了“谵语”，所以这个地方就用了一个“反”字。

“若加温针、必怵惕烦躁不得眠”。“温针”前边早就解释过了，温针的火热一方面可以加重里热，另一方面还会对患者造成精神上的刺激，并会因此致人大汗出。患者本来就有汗出，误加温针不单单是在精神上出现近似恐惧的症状，而且因为津液丧失、里热加重，那么烦躁也会加重，在这种情况下影响睡眠，应该是很自然的事。这个地方用“不得眠”，实际上在告诉大家：这也是一个因为虚热而造成的栀子豉汤证。后边我们还会进一步地说。

“若下之则胃中空虚、客气动膈，心中懊憹”。就是说前文当中的“腹满而喘”不是由里实证造成的，而且还进一步地明确了不单单没有里实证，而且还偏于虚。“胃中空虚”并不是一个具体的症状反应，而是一个病理解释，其实这儿还应该有相应的证候存在，这儿重点强调没有实证，所以其它的证候就没有去细论。“客气动膈”这是古人对这些疾病发展变化的一个病理解释，原意大概就是因为泻下而致人虚，疾病乘虚而扰动胸膈的意思。事实上，在没有实证的情况下误用下法，可能会出现多种变证，不仅仅是这一种变证。在这个条文里论述的是出现了栀子豉汤证的一种情况，病理解释就是“客气动膈”，实际上与热扰胸膈而造成的栀子豉汤证是一个意思，它的典型症状反应就是“心中懊憹”。

再接下来“舌上胎者、栀子豉汤主之”。关于舌诊，在经方理论里论述的比较少，也比较简略。特别是顶格排版的条文里，对于舌、脉论述得相对地比较少一些。这儿的“舌上胎者”，虽然既没有舌苔的厚薄、质地、色泽之分，但是它比常人的必定要厚一些，是一种比较厚的舌苔。

上边所论述的这三种误治方法，虽然方法不一样，但是从结果看，人体的内热、里热都没有去掉，所以这三种误治最后都有可能出现这种苔象。我在断句的时候，把它跟栀子豉汤断到一块儿了，后边说“栀子豉汤主之”不仅仅指的是误下之后，而是指的前边这三种误治所出现的这些变证，都应该用栀子豉汤来治疗。

对于这点，很少有人这么解释。做这样的结论，我总结了这么几条：

第一，从病理上看，栀子豉汤证对应的是一种典型的半表半里和里的虚热证，而且都是一种虚热证。它本身就不是一个实证，经过三种误治，再加上用了攻法，都陷于一种虚证，是完全吻合的。

第二，纵观经方理论对栀子豉汤的论述，它的适应证多数的是像

太阳病发汗后、下后、甚至是大下后；这条论述的就正是阳明病经过不同的误治以后，而出现的栀子豉汤证。换一句说，太阳病经过误用攻法之后，可能会出现栀子豉汤证；这条想说的的问题就是阳明里热证经过误治以后，在里热不得去又形成了里虚的情况下，同样可能出现栀子豉汤证。

第三，再来看看具体误治以后的不良后果。

第一种误治“若发汗则躁，心愤愤反谵语”，初看它就是一个调胃承气汤证，又有烦躁又有谵语，这个“反”字常常被人所忽略。这个条文论述的本来就是阳明病里边偏于虚的里热证，至少开始的时候就是一个白虎汤证，为什么是白虎汤证？后边第 222 条就说得很清楚了，它至少一开始就没有里实证，有严重的里热证但是没有里实证。所以经过误治以后，虽然有烦躁和谵语这样典型的阳明病症状反应，但是“心愤愤”一症不是调胃承气汤所能治的，实际上这是条文里要强调的。这个地方论述的真正的意思是说阳明病经过发汗以后出现这类症状，因为是误治，这是一种比较特殊的栀子豉汤证。换句话说，栀子豉汤在类似这样的条件下，也可能出现烦躁和谵语的症状。

第二种误治“若加温针，必怵惕烦躁不得眠”，要是出汗，它非常像桂枝甘草加龙骨牡蛎汤证，或者是桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证。但是只是病因层面上的相同，都是加了温针以后。这两个方子是治表证经过温针治疗以后所出现变证的，表证的特征是既没有里热也没有里寒。这条论述的是阳明病误加了温针以后，里热更加严重而偏于虚证的情况，根本就没有用桂枝类方剂的机会。比如桂枝甘草加龙骨牡蛎汤，这个方剂的药物组成比较简单，要用了这个方子的话，这么严重的里热用什么药来去呢？龙骨牡蛎是去不了这么大的热，它也不是去热的药，剩下的桂枝甘草汤是典型的温药，没有应用机会的。那到这儿用什么来治呢？后面有，实际上就是栀子豉汤。也可以用一句通俗的话来说，就是栀子豉汤在这类的情况下，也有可能出现怵惕

和烦躁的情况。“不得眠”当然就是栀子豉汤的本证了。

我之所以这么肯定地去理解这个条文，与我的亲身体会有关系。我曾经有过一次感冒，实际上是一个有里热证的感冒，早晨多少有一点汗出，又有点发热，实际上就跟这个条文中论述的非常相似。当时误认为是桂枝汤证，结果喝了桂枝汤以后，逐渐那个里热就不可收拾，人体后来出汗出的就虚了，后来我用了大量的石膏，当时喝下去以后有点轻快，但是人虚不耐那个药，很难受。最后到什么程度呢？晚上躺到床上，头一枕到枕头上，马上就有一种空的感觉，那种说不出来的烦躁感觉，头不敢枕在枕头上了，马上就得坐起来，人就虚得没地方能把它支撑住，那种感觉就没法睡觉了。再加上有点咳嗽和这种虚热，我就想这应该是一个栀子豉汤证，后来就吃栀子豉汤，就逐渐在轻，几天就好了。实际上好了以后我才对栀子豉汤特别地关注。

我们抛开这些都不说，误治的这三种情况，我们猜想的方剂都不合适，调胃承气汤不合适，桂枝类方剂也不合适，大家想没想过该怎么治呢？回过头来再看条文，条文里的“栀子豉汤主之”，不就指的上边三种情况嘛！实际就这意思！

我们再简单地回顾一下这段条文论述的重点，有这么几个方面：第一，阳性里热证不可用发汗的方法治疗，这是肯定的；第二，阳性里热证不可用加温针的方法治疗；第三，阳性里热证在没有里实证的情况下，也不可用下法来治疗；第四，阳性里热证经过发汗、加温针或者泻下的方法误治以后，多会发生或者可能会发生栀子豉汤证。这样理解，条文就显得比较丰满，它能跟临床实践相接轨。

接下来是第 222 条：“若渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之”。

这个条文的内容应该衔接哪儿呢？它从意思上说，咱们行文不像列表，别说古人当时那种写作条件了，我们今天写的话，可能词语的表达上比文言文要清晰一些，但是也得一个方面一个方面地写，不可

能在后边把所有的方面都加在一块，同步进行。实际上这个地方的内容就是衔接在“身重”之后的，前边论述的那个到“身重”为止，“身重”之后再接上“若渴欲饮水、口干舌燥者、白虎加人参汤主之”。它是指“身重”之前所论述的那些阳明里热证，在未经其它误治的情况下，如果再伴有“渴欲饮水、口干舌燥”，它就是白虎加人参汤主治之证。这也从侧面佐证了误治之前的证，就是白虎汤证。就是说“身重”之前的那些症状是白虎汤证。在这个基础上再出现“渴欲饮水、口干舌燥”的话，那就是白虎加人参汤证了。因为它有了津液虚损这个因素在里边。

第 223 条：

“若渴欲饮水（这有一个旁注“脉浮发热”），小便不利者，猪苓汤主之”。这一条在《宋本》里把它分开了，这条条文跟上边的第 222 条实际上是一样，它也是应该衔接在“身重”之后的，它就是指“身重”之前的这个阳明里热证，如果同时又伴有“渴欲饮水，小便不利”，那么就属于猪苓汤主治之证。其实这个地方，稍微仔细就能看出来，如果没有“身重”之前的那些症状存在，这个地方说是“猪苓汤主之”，不太对啊！因为五苓散也完全可以出现这种症状。

旁注“脉浮发热”，如果仅就这个内容来看，没有什么不妥，因为前边症状里就有“脉浮而紧，发热汗出”嘛。但是，它加在这个地方，特别是当又把这个段落断开，整个的猪苓汤这一块成为单独的 223 条，再把这个旁注窜入到正文里，形成了一个单独的段落以后，它对整体理解这个条文就形成了比较严重的误导了。按照咱们对《康平本》地解读，这个关于猪苓汤的论述条文，它的完整意思是什么？我们把前面“身重”之前的内容拿过来，为了方便大家理解：“阳明病，脉浮而紧，咽燥口干，腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热，身重；若渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之”，这段条文本来应该是这样子的。我们换个说法，这实际上论述的是猪苓汤可以治疗白虎汤

证伴有渴欲饮水、小便不利，也就是伴有体液代谢不良的情况，实际上猪苓汤证的适应范围就宽很多了。绝对不是把“若渴欲饮水”从这个地方断开，加上“脉浮发热”，绝对不是这个意思。

我们的视野再宽一点，在《金匱要略》“消渴小便不利淋病脉证并治第十三”章节里，《宋本》里的第 223 条又重新出现了，文字是一样的，就是把旁注的内容窜入到正文里，这是一个单独段落，但是到了《金匱要略》里，就没有了第 221 条和第 222 条的参照了，那么对猪苓汤证的理解影响就更大了。这样一点一点地把经方理论的内涵给剥离出去了，这么丰满的猪苓汤证，到最后必须得做一番解释才能理解。

猪苓汤证的病理应该是：里虚热证合并水实证（也就是停饮证）。

下面对这条做一个小结，其中的一些问题在小结里做一个直译（把它理顺一下）：阳明病，如果症状表现为脉浮而紧，咽燥口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热，身重者，为白虎汤证（这个为白虎汤证，完全是咱们加上的，因为它后边有佐证，不是随便说往经典里边加东西；再一个，把它翻译成白话以后，这个地方加上它，整个前后是互应的）。此时如果误以发汗的方法治疗，则可能会出现烦躁、心愤愤反谵语的情况；如果用温针治疗，则可能出现怵惕烦躁不得眠的情况；如果用泻下的方法治疗，则会胃中空虚，热扰胸膈，心中懊恼，舌上苔的，都为“栀子豉汤”的主治之证。在未经误治的情况下，如果同时还伴有渴欲饮水，口干舌燥的，为白虎加人参汤主治之证。如果渴欲饮水，小便不利的，为猪苓汤主治之证。这样直译，这段条文就比较准确了。

由于这段条文在《宋本》中进行了不合理的划分，所以历代的学者的解读多数都有偏差。正确理解这个条文的关键是要把握经方病理要素中的寒热与虚实，这个条文所论述的实际上是以“里虚热”为主的病理状态，所以说发汗后、温针后、泻下后都要以治疗虚热证的栀

子豉汤来治疗。这个条文对于深入理解“栀子豉汤证”有着重要的意义，另外对于白虎加人参汤证，特别是对“猪苓汤证”的理解会更全面。因为《宋本》不当的分段，产生了严重的误导，正确地解读《康平本》里的这一大段内容，可以全面理解这些方证。

下面看一看猪苓汤。猪苓汤方剂在《康平本》里出现在第 319 条，位置是比较靠后的。这个条文对于猪苓汤的论述是比较明确的，在这儿把猪苓汤全面地分析下，做一个方解：

猪苓汤由五味药组成：猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石各等份，原量是各一两。这个方剂中，猪苓和泽泻都是寒性的利尿药。茯苓性平，在这个方剂中既有利尿的作用，同时也有安神的作用，因为猪苓汤在其它条文论述中有一个“不得眠”的问题。阿胶是一味寒性的止血、补血的药物，并且它有一定的补益作用，也就是补虚的作用，但从经方对这个药物的应用来看，实际上阿胶止血和补虚的作用，应该大于补血的作用。现在社会上有很多人服阿胶，认为可以补血，但实际上，阿胶的补血作用在中药里面，起码在经方的应用里面，它的补血作用不是很大。凡是有阿胶的方剂，主要的作用就是止血补虚，这是比较主要的，真正补血的是当归、川芎、地黄这类的药。滑石是一味寒性的、有清热利尿通淋作用的一味药。在这儿把阿胶和滑石药性认识一下，对方证的理解就比较深刻一些。在经方中，用到滑石的方剂有六到七首，其中有一个当归贝母苦参丸，滑石是往里面加的（就是什么情况下加多少滑石），咱们也把它算一个，其中的大部分方证都是虚热证。比如像百合病里面，有两三首的方子都有滑石，百合病是一个典型的虚热证，再去看看其它的有滑石的方剂，都是对的虚热证，从这儿就能看出滑石的清热作用和石膏差不多，但是它跟石膏相比更适合虚热证，如果伴有停饮证的话，其作用要比石膏好一些。

猪苓汤在临床统计资料中表现的症状主要是：尿频、尿急、尿痛、尿有灼热感，这是表现最多的症状；其次是小便不利、血尿、腰痛、

发热、浮肿、纳呆、失眠。

舌质：以红舌为主，淡舌比较少一些，还有个别的黑舌、紫舌，都非常少，主要是表现红舌。红舌里面又有暗红、舌尖红、微红、红绛等，有一些微小的区别。

舌苔：有一些表现为无苔，还有薄黄、黄厚、黄腻、白厚、白苔的，从无苔占得分量比较大这点来看，这也说明人体比较偏于虚证。

脉象：有数、细、沉、弦、滑脉。偏偏没有统计到王叔和加的“浮脉”那个脉象，但是这不一定绝对不会出现啊。

在猪苓汤证的病理状态下可能会出现的一些现代疾病：肾炎、肾结石、肾盂肾炎、肾小球肾炎、肾结核、肾功能衰竭、膀胱结石、腰痛、尿道炎、特发性血尿、膀胱肿瘤、膀胱炎、泌尿系感染、乳糜尿、肾病综合征、前列腺炎、尿道炎、感冒发热多日不愈、小儿肠炎、肝硬化，流行性出血热伴尿少期、心源性水肿。

阳明病汗出多而渴者、不可与猪苓汤以汗多胃中燥、猪苓汤复利其小便^①也、（224）

注：《宋本》此处有一“故”字，即“猪苓汤复利其小便故也”。

胡希恕：真正到这个阳明病，啊，阳明病法多汗呐，他汗出的相当的多，内里头这个，啊，马上就燥结的时候，这一个渴它由热来的，啊，津液丧而渴。他由于里热，我们方才不讲了的，要是热，它对于这人身上的体液这耗伤的……（音频 027 完）的渴，若与猪苓汤复利其小便，必使胃益燥而渴益甚，所以不可与之。

所以说它这个书阳明病篇里的东西不尽属于阳明病，你看这一段与阳明病什么关系啊？它比较不让你这么用。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。

条文中“猪苓汤复利其小便也”，在《宋本》是“猪苓汤复利其

小便故也”，多了一个“故”字。

解读一下：

学习这个条文应该从两个角度分别来解读：第一个是正面含义，就是说对正确理解经方理论有益的一方面，或者说跟经方理论能够接轨的一方面；第二个是负面的意思，也就是说非经方理论的一些内涵，可能对读者产生误导的一方面。咱们把它分开来解读一下，我们既要正确理解古人的这些东西，又要客观地吸取精华、去其糟粕。

这条对于阳明病中因为汗出多而造成口渴的病理，分析得非常的好。阳明病常常会表现为多汗，并且因为汗出太多造成人体津液虚损，而出现口渴的症状反应，实际上就是白虎汤证，或者是白虎加人参汤证这类的情况。在病理上，因为里热而迫使津液大量排出体外，它会造成消化道内津液枯燥，甚至发生实热结于里的情况。所以说这儿的“汗多胃中燥”解释的也是比较恰当，与经方理论是吻合的。

但是它用上面的这些病理解释，来阐述猪苓汤的禁忌证，就偏离了经方医学的体系。我们一点一点分析啊，猪苓汤对应的是里虚热同时伴有停饮的一种病理状态，也就是阳明病而且是虚证的同时还伴有体液代谢不良。如果只是里热证，应该是白虎汤类的方剂。这个条文它忽视了猪苓汤的主要的病理要素中“停饮”这个因素。猪苓汤适应证的关键在于阳明病的同时有没有停饮证！如果是没有停饮证，无论是有汗也好，无汗也好，都没有使用猪苓汤的机会。所以说仅从阳明病汗出的角度来确定有没有应用猪苓汤的机会，等于是本末倒置了，没抓住主要的东西。说再延伸一下的话，它其中反倒是还有阳明病如果没有“汗出多而渴”的症状的话，都可以用猪苓汤来治啦，那就越来越偏啦！我们也是尽可能地把各方面的因素都考虑到，当然这里还有另外一个因素：就是说当人体汗出过多的时候，它就会影响到小便，会出现小便少的情况。但是这个小便少，与停饮证有着质的区别，不是一回事儿。所以汗出的多少，不是能否应用猪苓汤的关键，它充其

量只能算是一个相关的症状。

有关这一类的内容，经方是怎么论述的？其实这个条文里假设再加上一句话：“汗出多，虽小便不利，不可用猪苓汤”。意思就完全变了，它就把界定有没有猪苓汤证的关键因素给明确出来了，但是条文里没那么写。大家看看在其它的地方怎么论述的呢？经方里有过这样的论述，体液损失过多而没有小便了，不要紧，不要管它，让它津液恢复了自然就好了，论述得很清楚。但是这个地方论述的太片面啦。

之所以出现这样的条文，应该是条文的作者临床中误用猪苓汤的经验总结。这应该说没太大的问题，这个作者肯定是在这个情况下误用过猪苓汤。换句话说，在没有猪苓汤证的情况下误用了猪苓汤，而且那还是人出汗多又没有停饮的情况，用猪苓汤肯定是不行啦。问题出在这个作者对经方理论没能全面深入理解，这个条文虽然总结了在临床中的这些教训，但是因为它的理论基础建筑在对经方理论没有全面理解之上，所以说总结错误的同时又出现了新的偏差。

脉浮而迟、表热里寒、下利清谷者、回逆汤主之、①（225）

注：《宋本》此处有四逆汤方及方后注，此从略。

胡希恕：那么这一段呐，我们在太阳篇里头，讲那个白虎汤，啊，脉浮滑，说是表热里寒，那个时候，啊，他后边也注了，啊，说是恐怕是白通汤，啊，所以那一个跟这一段呐，都串了。那一个“脉浮滑”绝不是“表热里寒”，这个是“表热里寒”，啊，那个“脉浮滑”就是表里俱热，就是内外俱热了。那么这一个呢，假设是表热里寒，这冲着少阴病说的，少阴病也在表啊，表热里寒，同时下利清谷，用四逆…四逆汤不为不可。因为这个表里同时有病，啊，那么下利清谷这里虚得厉害，舍表救里这也…这也是定法了。但是不应该用…不如用白通汤。所以那一个，我们讲那一节的时候，我让你们也翻翻后头，

那王叔和他们也都缀了，说那个白虎汤那一个表热里寒，一说呢就是白通汤。恐怕是这一节儿，那一节儿不会是白通汤的，“脉浮滑”它不会白通汤的。那么“脉浮”还是表，“迟”是里寒，是吧？这个脉与这个表热里寒这个断语都对。那么如果要是两解其表里，应该用白通汤。白通汤这个药啊，它是附子、干姜，搁大葱，葱白。这个葱白这是发汗药，啊，温性发汗药。那么那个少阴病下利，我们后头有的，用白通汤。那么这一个就像我们用葛根汤治阳性的这个…啊，太阳阳明合病那个下利是一样的。下利现表证，有用解表治下利的这么一种手段。他说这个病下利它是一个病，啊，就是痢疾了。他现表证他就要由表解，他这个疾病的反应就是这样子，所以你吃葛根汤啊一发汗，热一出，这痢就好了。那么如果现于阴证，你用葛根汤是不行，需要用白通汤，啊。这个白通汤啊，它既温里也解表，也是个两解的法子。那么这一个地方，他说是表热里寒，表热有这个，啊，嗯…有表证的一种这个热象了，啊，里寒这就指着下利清谷了，那么这一个，我认为要是用白通汤还是较比恰好的。这个做个研究啊，那么这一个，这个在这一段上他没提，可是在白虎汤他提了，一云白通汤，啊，是白虎汤恐怕不对，他冲着“表热里寒”这四个字说的。那么这一段呢，如果就是用四逆汤也不算错，所以咱们没法给他…也不必改，因为这个里证表证同时存在，这个里证要是虚寒，可以先救里而后解表。有那么一个治法。这是我们，因为上次啊，讨论那一个，啊，白虎汤，我们提到这一个了，我说将其呀，有这么一节。他这个书啊，是有错的地方。这一个错，王叔和也是搜集的了，也不是现成的这个东西，啊，他也找多少本净是抄写的，啊…那么这里头错误地方是不少，啊。那么陈修园说呢，不兴…不应该有错，他说这个，啊，王叔和去这个，啊，后汉，为…为时不远呐。这也是一个看法了，那么实质呢，真是有错的。那么这个表热里寒呐，我认为这个，将来我们讲到少阴病的时候啊，再重讨论这一个，啊，现在留在这儿。但是这一

个可不能够搁到阳明病里头，他为什么搁到阳明病里？就像我们在太阳病里头他说些这个，啊，半表半里病。他是不可发汗，你看像这柴胡证，他不能发汗，这个少阳病，他搁到太阳篇里头。那么这一……以下这几节全不是阳明病，全是不可下的。不但不可下，连白虎汤都不能用，他都是反面的东西，他给你来着…啊。我们研究的是要…要除热，要攻，要吃下药。但是呢，有些这个证候啊，啊，是不可攻，也不可去热的，那么这几段就是这样子。其实呢，这个不应搁在阳明病篇里头。

李冠杰：《宋本》里面是四逆汤。这个条文在《康平本》里是降一字格排版的条文。

下边我们解读一下：

这个条文论述的是一种阴性的里虚寒证，它并不是阳明病。从理论上说，这个条文就不应该出现在阳明篇里边，不单单它论述的症状当中，没有阳明病的症状反应，而且它的治疗方剂也与阳明病无关。我们客观地看，这本书年代久远，很多东西，像这一类的问题就难以弄清它其中的原委。为什么这个条文要放在这个地方？到底是他原作就这样，还是后来整理的过程当中加在这个地方了？就已经很难做出一个明确的结论。我们现在学习只能就条文本本身来解读。

“脉浮而迟”，指脉轻取即得，但是搏动次数比常脉偏少的这种脉象。因为整个的条文述证当中，没有任何表证的症状反应，所以说这个“脉浮”也不能视为是表证的一种证候。再从四逆汤证的临床统计资料来看，四逆汤的证当中，确实有“脉浮”的情况存在，而且不少，尽管它不是一个主流的脉象，但是占的比重也不是特别小。我们学习这个条文的时候，应该把这个地方理解成四逆汤证有时也会出现“浮脉”。“迟脉”与四逆汤证就比较吻合了，它应该算是标准的四逆汤证，它是里虚寒的证候。

“表热里寒”，本来按照作者的本意，它应该是一种病理的解释，

而不是症状反应。“里寒”跟脉和证（那不有“下利清谷”嘛）还有治疗方剂，都是相吻合的。但是这个“表热”，我们要做具体地分析，在前边的学习当中，已经对表证的寒热属性做过专门地探讨，在经方医学当中，表证实际没有寒热属性，但它不是说没有寒热的表现，也不是说它不受外界寒热的影响，而是它所表现出来的寒热，或者说外界寒热对它的影响，对疾病的本质没有影响。在治疗当中有热证，则用寒药；有寒证，则用热药；没有寒热就用纯解表药。所以说它对疾病的本质没有影响。也就是说，在病理上表证没有寒热属性。而这个条文论述的“表热”，也出不了这个范畴，尽管这个表热很明确，说的就是“表热”。咱们可以分析下：

从这个条文的论述看，这个表热它指的不外乎两种情况：第一个，它根据什么说是表热？它就指的脉浮而言，因为有脉浮的这种症状反应，这个病因与病理，应该有表热的因素存在。大家千万不要以为这是我的解释啊，这是用这个条文作者的观点来解释。你不妨去看一看其它的降两字格排版的条文，通看一下，你很容易的就会发现，这一类条文的作者，确实有将脉诊机械化、绝对化的这种倾向。第 140 条的后半部分非常明确。这种解释比较贴近于作者的本意。但事实上与医理通不通？其实我们之前早就有论述了。第二，他另有所指的是，另一种可能性，它还可以是指体温偏高的这种症状。

在临床当中，四逆汤证确实有发热的案例存在。这样解释虽然与他这个作者的本意有一定的差距，但是它却能与临床实践接轨。实际上，体温偏高并不是表证所特有的症状反应，三阳病，包括三阴病，都有可能存在体温偏高的这种症状。我曾经做过这样的事，就是把《伤寒》和《金匱》里边所有的症状，都把它剔出来，凡是含有发热这两个字的这种症状，都列到一块，涉及到的条文数量非常大，而且涉及到各种类型疾病，都可能出现发热这种情况。所以说我们把这个表热理解成发热的话，反到是更贴近临床实践。再和“下利清谷”合在一

块，这就有点近似于现代医学当中的急性胃肠炎，按现代的医学的说法，人比较虚弱，又得了急性胃肠炎，这一类的情况。

“下利清谷”，就是指不单单有腹泻的情况，而且大便当中还有没有消化的食物。这是人体的整个消化道处于一种虚寒的状态，并且因为这种情况，而使整个人体都陷于机能沉衰的阴性证的这么一种病理的症状反应。

因为这个条文的论述比较简略，后世在解读的过程当中，它常会依照四逆汤证的常见的、其它地方论述四逆汤的一些症状反应，做一些补充，其实没有必要。如果临床当中，有条文当中论述的这些证，同时还有比如手足逆冷、一味的恶寒、但欲寐之类的，像这种阴性证的症状反应的话，那么用四逆汤，那是绝对没有问题的。

但是真正这么去理解，反倒是掩盖了这个条文的本意，你试想一下，临床当中你假设碰到一个就是条文里边论述的这种病人，就这样的症状，其它的症状没有，我真碰到过这样的病人。所以我敢这么说，这个病人就是平时没有什么明显的不舒服，就是大便偏于溏，它跟下利清谷不一定非得这么确切了，脉又浮又迟，甚至还有点偏大，就这样的一个人，你给他什么药吃呀，用四逆汤绝对没问题的。

若胃中虚冷、不能食者、饮水则哕、（226）脉浮发热、口干鼻燥、能食者、则衄、（227）

胡希恕：226条：“胃中虚冷”，啊，他当然就不能吃东西了，这咱们头前儿也有啊，啊。阳明病不能食者名……名中寒，啊。那么胃虚他就要停水，停水就不能吃东西，啊。咱们现在，啊，治这个关于胃病，说是不愿意吃东西，大概都是脾…啊，脾虚，有…有停食停水了，他这个说胃中虚冷了。虚，啊，就指着胃气虚。同时呢，有

寒，他搁个冷字。而不能吃。那么饮水呢？由于胃气虚，水也不纳，他要哕逆的。当然这更不能吃泻药了，是不是？这都应该是，啊，虚寒在里的病，不应该搁这个地方。

227 条：“脉浮发热”这是外有热了，所谓表热了。“口干鼻燥”，啊，那么这是这一个，应该说是…也可以说是津液枯燥，热伤了津液，啊，口干鼻燥，那么也可以说是少阳病，少阳病都是一种官窍，啊，发热，口苦咽干，啊，耳聋目赤，都属于少阳病。也可以说是这是半表半里也有热。“能食”呢，是里有热。那么这是表里内外俱热呀，没有不伤…伤人的这个津液、血液，啊，所以他容易衄血的。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边是降两字格排版的条文。

在《宋本》是两段内容，是 226 条和 227 条；但在《康平本》是同一段内容。

第 226 条咱们直译一下，它的结构稍微调整一下，大家看是不是说的这个意思：饮水则哕，不能食的为胃中虚冷所致，属于里虚寒证。就是因为里虚寒证所造成的肠胃功能低下。不单单对食物的消化能力很低，而且对水分的吸收能力也严重的不足，所以就造成这样的症状。喝了水以后就想吐，稍微多喝一点就想吐。

第 227 条也稍微调整一下，就是：脉浮发热，口干鼻燥，能食，鼻衄的，多为较为严重的热证。这样呢，倒是症状非常明确地给它做一个病理的界定，反倒是有意义。这实际上是里证与半表半里俱热的一种病理状态。脉浮发热和能食这都是里证的症状反应；口干鼻燥和鼻衄，既有里热证也有半表半里证的成分。当然，这个脉浮发热、鼻衄，也有可能存在表证的因素。但是因为条文的论述，就交代得不清楚，也没有治疗方剂，所以，说这是个热证，是准确无误的。

咱们就肯定这一点，其他的，也没有必要去过多地妄加推测，本身这个条文，跟方证条文相比，价值也没有那么高。

阳明病下之、其外有热、手足温、小结胸①·心中懊憹、饥不能食、但头汗出者、栀子豉汤主之、（228）

注：“小结胸”《宋本》作“不结胸”。

胡希恕：阳明病，啊，下之，其外有热，手足温呐，那么下之后外还有热，手足还温，手足温者说明有内热了，啊。手足厥冷，咱们说胃虚多寒嘛，啊。那么手足要热呢？啊，就是里有热。“不结胸”，他主要说的什么呢？这一个也是下之太早了，啊。就是阳明病，这一个由头那几节来的，他本来是白虎汤证，内里并不实，你下后了，啊，不但热不退，外还有热，手足还温。那么总而言之，他这个，必把这热留下了。咱们说那个栀子豉汤就是“遗热不除”，他药不对头，你只是着伤他这个…伤其里，但是热不能退，啊。所以不是说，药…药用过了还能治病，它不能治病了。所以这个外还有热，手足还温，啊，这说明这个泻药用之不当，这是白虎汤证应该是。“不结胸”这一句话搁这儿干什么呢？他是对于这个栀子豉汤说的。他不说是反不结胸，应该结胸，他不是那个说法，啊。这个栀子豉汤啊，头前你翻过来看就明白，“胸中窒，心中懊憹”，这都是栀子豉汤证。“胸中窒”它不是结胸。他也觉得这个地方啊，啊，发窒，窒塞，啊，心中也懊憹，这个结胸证也心中懊憹，这个头前儿也有。他说他只是胸中窒而已，并不是结胸，他这，他这个意思啊，就让你这个栀子豉汤证与这个…啊，这个大陷胸汤证，让你对照、鉴别，就让你在临床上要注意这几点。那么这个人胸中窒，也心中懊憹，你给吃这个大陷胸汤，这了不得了，那就坏了。他这个“不结胸”，这个…这个三个字啊，他这个…意思含蓄很多。就是我们在这个，问病的时候总要注意的，这个胸中窒，你摁摁他这个心下这个地方，要实者他拒摁，啊，他不光懊憹、胸中窒而已。这一个…大陷胸证它不然了，那，啊，你不摁他这个心下也疼，那摁他更…更什么了，而且摁之石硬。那么这个地方

他就让你鉴别。“饥不能食”，他有热，饥。但是这一种饥是客邪之热了，就我们方才说那一个，啊，那么“胃中空虚，客气动膈”，这么一种热，不是胃气强，不是胃本身，啊，它这个挺亢…亢…亢奋的、亢盛的，不是的。所以有热他也能饥，但是他吃不了东西，不能食。“但头汗出者”，这一种热往上攻，啊，头也出汗，这是栀子豉汤证。这就是那一个，啊，他这一段呐，也应上边这个三阳合病，啊，和我们那两大节儿，所以这一个，啊，下…不应该下而下，这个热不能除的。那么最容易辨证的就是栀子豉汤证，啊，而遗留虚热不去。这个虚热这是中医的看法了，那么就是胃中不实。那么在这个，啊，要拿照现在的咱们看呢，总是还是在这食道啊、胸膈这个地方啊，有些发炎证，啊，就是拿着西医说，啊。你像食道炎呐，或者什么东西呀，啊，心中懊恼啊，他总是有热象。那么古人就说呢，反正胃里头没东西了，啊。所以他这个虚烦、虚热。但是，这一个方子不治虚的。这个栀子这个药啊，它苦寒药，啊。那真正的咱们说是这一个，你像那虚劳那个虚呀，用这一个机会很少，它不治那个虚。他就是冲着阳明病这个胃家实说的。

李冠杰：这是顶格排版的条文。

旁注“小结胸”，《宋本》里边是“不结胸”，这差距比较大，咱们后边做一点分析。

下边我们解读一下：

这个“阳明病”，从“下之”以后，不单单病没有痊愈，而且还出现了新的变证，还给出了相应的治疗方剂来看，它应该是属于里热证但没有里实证。实际上这也是这个条文论述的一个重点，虽为阳明病，但是在没有里实证的情况下，不可使用下法。这儿跟第 221 条又接上轨了，实际上是一回事啊。论述的是具体情况不同，但是论述的重点、方向是一样的。

“其外有热”，肯定是指的体温高了，说明虽然经误下，但是里

热证仍然没有得去，还是一种热证。以前就是一个里热证，不可能下了以后成为表证，那不可能的。

“手足温”，也是里热证的症状反应。值得注意的是，这个条文虽然有“饥不能食”这么一个症状，但是这儿的“手足温”，也绝对没有那个所谓的“系在太阴”的意思，因为它压根就没有里虚寒证的特征，所以说这个“手足温”，跟那个顶格条文之外的论的“手足温”“系在太阴”不是一回事。

旁注“小结胸”，在《宋本》是“不结胸”。咱们从这个条文的论述来看，“不结胸”，虽然说可有可无，而这人没有结胸证，你再说一句这话真可有可无，但是它放在这个地方至少还可以起一种警示作用。但是“小结胸”就不对了，没有结胸证，你大小都不对。《康平本》里怎么会出现“小结胸”呢？这个条文里面压根就没有这类的证。一般这个加注的作者也不会知识贫乏到这种程度，这个很有可能是抄写过程当中的笔误啊，抄错了。“不”字和“小”字差那么远，怎么可能呢？但你看一看那个草书，“不”字跟“小”字非常接近，如果有一点残缺或者什么的，就特别像一个“小”字。

“心中懊憹”，这是典型的栀子豉汤证的症状反应。

“饥不能食”，这是由于在没有里实证的情况下，误用了下法，而造成胃肠功能虚弱的一种里虚证。虽然用了下法，但方与证不能相应，里热仍然没有去，主观上还感觉想吃，但是胃中却不能纳食，就是说胃里装不了，功能太弱了。

“但头汗出”，有两个方面的因素造成：第一个是误下以后，津液有所虚损；第二是误下虽然致里虚，但是里热没有去，人体因为里热而出汗，因为津液虚了，身上不得汗，最终表现为只是头上有一点汗，身上不得汗出。

这个条文的论述，不但是对第 221 条的理解有着重要的参照作用，而且对栀子豉汤之类的方剂，也就是说类方的方证，对它们的认

识和理解也有着非常重要的意义。但是它应该跟第 221 条相结合起来读。

这个条文和第 221 条，都是论述阳明病当中仅有里热而没有里实证，说白了就是白虎汤证或者白虎汤类方证，但是经过误治以后，人体陷于虚热证的一种病理状态，而治疗方剂也都是栀子豉汤。这就可以从侧面佐证第 221 条当中发汗、加温针和泻下所出现的那些变证，都是栀子豉汤证可能出现的，都是栀子豉汤所主。

通过对这个条文和第 221 条条文结合起来学习、理解，我们再进行一步对栀子豉汤及其类方的相关条文做一个整体的解读：

栀子这一类的方剂所对应的大部分都是因为发汗、涌吐、泻下、温针等攻法，而且是误用了攻法，使人体陷于一种半表半里和里的虚热证的病理状态。可是人体和所患的疾病，以及误治的方法都不同，有的人强壮一些，有的虚弱一些，患了病了也不一样。比如有的是肺炎，有的是肾炎；误治的方法也不一样，有的是用了发汗，有的是泻下。所以说它出现的变证也是多种多样的。

这类疾病最好的治疗药物就是栀子，这是经方里面的一个很重要的内容，但不仅仅是一个栀子豉汤所能应付得了的，所以又延伸出了好多栀子豉汤的类方。比如半表半里和里俱热的虚热证，就是栀子豉汤所主；半表半里虚热又伴有里虚寒证的，像栀子生姜豉汤和栀子干姜汤；若伴有气证的，有栀子厚朴汤证；伴有里虚证的，有栀子甘草豉汤证；伴有里实证的，还有栀子大黄汤证等等。最能说明问题的，是第 393 条当中的枳实栀子汤，这个方证实际上就是在栀子豉汤的基础上加了一味枳实，它治的是大病瘥后劳复者，大病好了以后不慎又复发了。

凡是大病，都会致人虚，比如一些实证，用大承气汤下了以后，人也得养一养，他也陷于一种虚证，如果好了以后不慎或者说饮食不洁等，它又复发了，按着经方的治疗原则，如果真正是以前的病证重

新出现的话，那还得用那个方剂。比如是一个大承气汤证，喝了大承气汤以后好了，这个实热去了，又经过比较重的体力劳动，累了以后又猛吃，吃了以后又结住了，又出现大便不通，肚子里头实满，你用栀子豉汤能治疗吗？再加上枳实也治不了啊，大家想想是这么回事？还得用大承气汤。

所以这个“劳复”，实际上说的就是一种非常复杂的虚热证，既然是栀子类的方剂，它就离不了虚热。具体到这个枳实栀子豉汤，还有一定的气滞，气实的问题。栀子类方中出现了这么多类似于调胃承气汤证的症状，比如谵语，看似不像栀子豉汤证的反应，怎么也要用栀子豉汤来治啊？大家看到这儿就比较明白了，就是人太虚了，很多症状就不能按照常规的办法去治，这个地方应该这么来体悟。

另外一个小问题，第 228 条是顶格条文，把降一字格和降两字格排版的条文剔除出去的话，它应该是排在第 223 条之后的，就是说跟 221 条、222 条、223 条那一段是接着的，都是以栀子豉汤证为主要的论述内容，所以说这两段条文有一定的内在的联系。实际上这两段条文在阳明篇里边，重在示范，就是里虚热证的治疗，虚和热在这儿是一个关键点。

下边做个小结：阳明病，当没有里实证时，误用下法治疗后，患者表现为：其外有热，手足温，心中懊憹，饥不能食，但头汗出者，为栀子豉汤主治之证。

这个“手足温”，如果放到第 221 条里边，比如温针以后出现的，很多人就会把它解读成这不是栀子豉汤证。但这个地方来看，可能是这个“手足温”，在经方里边出现在栀子豉汤证里边仅有的一个。而且常常很多人都不会把它当作栀子豉汤证的一个典型症状。实际它本身也不是一个典型症状，包括像谵语之类的症状，都不是典型症状。而是在对虚证误用攻法以后，人虚到一定程度，在这种特定的条件下出现的。在这种情况下，按经方理论应该用栀子豉类的方剂来治疗。

大家学了这两条以后，再回头去看看栀子豉汤和它的相关方剂，肯定认识会更全面一些。

阳明病发潮热、大便溏、小便自可、胸胁满不去者、柴胡汤主之^①、^②（229）

注：

1. “柴胡汤主之”《宋本》作“与小柴胡汤”。
2. 《宋本》此处有小柴胡汤方及方后注，此从略。

胡希恕：这一段很好，啊。这一段与我们治痢疾上，啊，很有，啊，很有些这一个…对于用柴胡的这么一个…启示。他说这个“阳明病发潮热”，这个“潮热”热得相当凶了，啊。同时，这个“大便溏”就指着稀呀，啊。那么痢疾，他古人都是下利，啊，他也说大便溏。其实这个他是，啊，冲着潮热下利，它总是属于痢疾这一类的。“小便自可”，啊，他不是…搁个小便自可，当然这个病人也有这一个，他小便是正常了，小便正常，这个大便溏，他不是水谷不别，啊。不是咱们说水泻、水谷不别那一种。他是由于热造成的，“发潮热，大便溏，小便自可”，不是水谷不别呀。所以这个辨证啊，啊，我们在这个临床上问病啊，要注意这一点。这痢疾有可以利小便的，他这小便不利，这是水谷不别，啊，造成的，利小便他这个下利，啊，就可以好。他小便自可呢，你不要利小便了，这么样子热，你越利小便内里头热越大，那就不行了。所以这个痢疾呀，啊，腹泻也是一样啊，有的，给利小便把这个病给弄坏了，啊，这样就不能。“胸胁满不去者”，他这个胸胁满不去呀，不是说是由于少阳病转属阳明病，还不是很的。那么“阳明病，发潮热，大便溏，小便自可”，啊，而有“胸胁满不去”，就是有这个证候存在了，这是一起发作的。这一种病很多呀，啊，尤其这痢疾，这…这…这天快热了，快有了。那么如果现

柴胡证，他必须有胸胁满。没有胸胁满不能用这个柴胡剂。可见这一个柴胡汤这个祛热力量相当强，啊，所以这个潮热，这是个阳明病的热了，啊，潮热其热如潮嘛。但是这个柴胡啊，啊，大量用能解决这问题，但是必须现柴胡证。所以这一个，啊…就得辨证，你不辨证随使用药那也是个，也是一个主观设想，那一个不行。他这个柴胡证，就拿着小柴胡汤说，一定要呕，啊，发热而头痛，啊，胸胁苦满。胸胁苦满最准。咱们开始讲那个柴胡汤，“与正气相搏，结于胁下”。结于胁下，啊，就是胸胁苦满那个意思。而且我们看那个《神农本草》他也说得很清楚，它是“主心腹间，邪气积聚”，啊。这个柴胡有…有…有…啊，它这个证候啊，是现于这个心腹之间，啊，胸胁部位。那么这一个病，就是一发作又有潮热，同时下利，那么现柴胡证。这一种痢疾，啊，无论是肠炎，大有用小柴胡汤的机会。我用这一个方子啊，治过噤口利。因为这个柴胡证啊，它是呕而不欲食嘛，啊，“心烦喜呕，嘿嘿不欲饮食”，我就根据这一个。这是…这年头多了，啊。那么他这个人呐，就是，一痢疾就发高烧，就说这个“潮热”这一类的，啊，一点东西不能吃。一天他这个痢疾是无度啊，他就能吃西瓜。嘿，嘿！他家人老给他买西瓜，他吃点西瓜觉着好，他就是内里太热了。我到那儿一看呐，我一摁他那肚子些软，没有，里头没有什么…啊，属于这个胃家实的现象，我没敢用大黄。我想了半天，他这个，恶心的厉害。这一种痢疾叫禁口痢呀，这一个痢疾死人，这个死亡率最大。尤其他所下那个都像这个红血汤子，所谓赤痢那一种的。这一个人今年正好还来我们家串门来了。他就这么个病，我就给他用小柴胡汤加石膏，他吃了，连下吃了七副药，我一个药…一个药我也没有增减，啊，一直到他好。我当初给他用那药的时候，有一个大夫啊，他也跟他认识，他看我那方子，他摇摇头，他说应该用大黄啊，啊。这个痢疾不能是净用大黄，他当然也有里急后重，啊。但是他里头没有，没有实象，就是有热，就是这个所谓的发潮热，啊，那么小

便挺好，小便自可，啊，也不少也不多，但是黄是特别黄的，啊。呕而不能食。那么这一个方子不光我用，也有很多人用。尤其是这个小儿痢疾呀，最多了，这个小孩子，啊。那么就用这个小柴胡啊，他有肚子疼什么加点芍药，啊，这个加…这个芍药也不光治肚子疼，这个芍药对这个下利也是有好处的，挺好使。那么这一段他就说明这一个，他搁个阳明病，是热。那么这一个痢它是热痢，啊，发潮热这一个痢，小便自可，这不是水谷不别那一种…那一种痢，胸胁满不去这是柴胡证，啊。那么这个意思呢，就是这一种热痢有用柴胡，啊，小柴胡的机会，但是必须得柴胡证，啊。所以我们对于方剂这个…这个认识啊，非彻底不可。不是说遇着痢疾就用小柴胡汤，这错的，啊。没有柴胡证不行的。这个小柴胡汤，你要加上白芍，这不就有黄芩汤了嘛，黄芩加半夏生姜也治呕，啊，黄芩也治下利，所以他这个，这一个方子，这个小柴胡汤这个药啊，根本它是，既是解热剂又是，啊，健胃剂，啊。人参、半夏、甘芍…甘草、生姜、大枣，都是健胃的，啊，治呕的。

李冠杰：这一条在《康平本》是顶格排版的条文。

条文当中的“柴胡汤主之”，在《宋本》是“与小柴胡汤”。另外呢，《宋本》在这个条文后边，附有小柴胡汤方和方后注。

我们解读一下：

这个条文当中的“阳明病”，应该是指的患者有某些阳明病的症状反应，或者说近似于阳明病的症状反应。“发潮热”本身就非常接近阳明病的症状。如果患者再有不恶寒，甚至恶热，其外貌就更像阳明病了。所以，这个阳明病应该有阳明病的某些外貌特征。

“发潮热”，就是指的体温很高，其热如潮。但是这儿没有“日晡所”这样定时发热这个特征。所以，看似像阳明病的症状，实际这是一个少阳病的症状反应。

“大便溏”就是指的大便溏泄，又达不到下利的那种程度。这个

“大便溏”是由于里虚而偏于热造成的，就近乎于胃肠炎之类的疾病。那么怎么知道他是里虚而且又偏热呢？治疗方剂在那儿放着呢。他也没有明显的其他的可以证明有虚寒证存在的，真要有虚寒证，小柴胡汤也用不得。

“小便自可”，就是指的小便基本上正常。一个小便正常就应该不是症状了，在这儿强调的是什麼？强调的是没有体液代谢不良的水证。同时，证明大便溏这个症状，不是因为水谷不别所致的，与水证无关。纯粹是由于里虚偏热的这种情况所造成的。

“胸胁满不去”，这就是典型的少阳病的症状反应了。

“柴胡汤主之”，在《宋本》当中改成了“与小柴胡汤”。

如果从条文的内容来看，这个地方应该是“小柴胡汤主之”，这个条文，虽然冠以阳明病，但是他的述证当中，没有实质性的阳明病的症状反应，就一个发潮热比较接近阳明病，还没有阳明病“日晡所发潮热”的发作特征，所以，实际上也是少阳病的一个症状。在实际临床当中，大柴胡汤、小柴胡汤证都有可能出现高热的情況，这很常见。如果加上“胸胁满不去”，虽然还可能存在着其他的某些阳明病的症状反应，但是阳明病在这儿占的比重非常小，主要的还是少阳病。那么在经方里面，三阳合病都要取少阳而治之，那么少阳阳明合病，也是应该先治少阳病。而且，这儿阳明病的比重又那么轻，根本没必要去考虑它。所以，就应该用柴胡剂，这肯定是要用柴胡剂治疗。

那么“大便溏”，在这个条文当中，应该是由于里虚证所致。如果是里虚证所致的话，就没有用大柴胡汤的机会，那么这个地方，就应该是“小柴胡汤主之”。但是要如果说，我们的分析面再宽一点，这个条文论述的也是半表半里的虚热证合并有里热证的这么一种情况。与咱们常见的这些病理状态不同的是什麼？这个地方出现了“大便溏”这么一个证。一方面说明里虚热证不仅仅会出现大便干、大便硬这一类的状态，同时也可能会表现为大便偏于溏。事实上，在少阳

病的病理状态这种前提下，大小柴胡汤证都有“下利”的症状出现。换一种说法，大小柴胡汤都有治疗下利的机会。

可是，值得注意的是什么？虽然有“大便溏”的症状，但是不能有里寒证存在，不管是大柴胡汤证也好，还是小柴胡汤证也好，都不能有里寒证所造成的下利。

我记得跟大家说过，小柴胡汤在应用的过程当中，有一个很重要的禁忌症，那就是里寒证。也就是说他有小柴胡汤证的四证俱全，但是人一旦偏于里虚寒，你一定要合上理中汤，或合上吴茱萸汤。仅仅用小柴胡汤，或许喝第一剂的时候，觉得还行，但后边马上就要出现变证，非常不舒服，而且有时候胃里边难受的不得了。从这个意义上不妨把视野拓展得宽一点，有少阳病的症状，又出现了“大便溏”的情况，偏于里实的就是大柴胡汤证，偏于里虚的就是小柴胡汤证。从这个条文看，恐怕是偏于小柴胡汤的机会比较多一些。因为里实证得有明显的里实证那种证候才对。

下边呢做个小结：

阳明病症状表现为发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去的，为小柴胡汤的主治之证。

学习这个条文，可以延伸出来经方医学对于下利的治疗，与其他的任何医学都有明显的不同。大便溏实际上也是一种胃肠炎，近似于下利的情况。那么对下利的这个症状，在《伤寒论》和《金匱要略》里边都有专门的章节加以论述。但是只有整体地解读经方理论，才能够得以见到经方理论对于下利治疗的一个全貌。

在经方理论当中，下利不仅仅有寒热之分，也有虚实之分；不仅仅有里证，也有在半表半里证和表证病理状态下，发生的下利。

实热证的下利，有大小承气汤证；虚寒证的下利，有吴茱萸汤证；表证的下利，有葛根汤证；半表半里证的下利，有大小柴胡汤证；里证的下利，有理中汤证；阴性证的下利，有四逆汤证、通脉四逆汤证

等等。我这只是举的一些比较典型的例子。

因此胡老曾经做过一个专题的讲座，专门讨论对下利的治疗。

咱们不要把眼光仅仅局限在下利这一个证上。通过这个讨论，我们能感悟经方医学理论的内核，不仅仅是下利一个证有这样的特征，有这样的规律。在经方医学里边，好多证或者疾病都有这样的规律存在，可以用很多方子去治疗。处在不同的病理状态下，治疗的方法不一样。这正反映出经方医学对于疾病的认识，更加符合事物的本来面目，大家不要嫌它复杂，因为这是事物的本来面目。你要是见到下利就用一个办法治，那到最后，总是有治不了的时候。

阳明病、胁下硬满、不大便而呕、舌上白胎者、可与小柴胡汤、上焦得通、津液得下、胃气因和、身濈然汗出而解、

(230)

胡希恕：“阳明病，胁下硬满”就胸胁苦满呐，啊，胸胁满不去，就是…就是那一个。“不大便而呕”，那么这一个，他虽然说是阳明病，这个是少阳病。少阳并与阳明，他是有里热了。要不他不大便哪来的呀，是吧？里头有所结。但是胸胁…啊，胸胁满和这个呕，这全是柴胡汤证。“舌上白苔者”这一个也很重要，啊。我们…现在，这个舌头，也是在临床上一个，啊，辨证的一个方面呐，可不能够…是病就是看舌头就行了，那不行的。这个白苔呀，是有热而不实的一个苔。你像这一个，啊，咱们说这白虎汤证也这样子，一见黄了就里头有实了，啊，就实在的实啊，就是实证。舌上白苔他还是，虽然热他不实。那么那一个不大便，他先是一个少阳病，啊，柴胡汤证，你就与小柴胡汤就行。那么为什么不大便呢？他底下有解释。我们说这个柴胡证啊，它结于胁下，啊，正邪交争结于胁下。他那一个地方有所结，影响上焦，啊，津液它不往下，上焦不通嘛。那么这一个柴胡

呢，它就解这个地方结，胸胁…啊…这个地方。所以上焦得通，津液得下，啊。这个津液呀，才能够得下。

李冠杰：这段条文在《康平本》是降一字格排版的条文。

下边我们解读：

“阳明病”在这，指的有某些阳明病的症状反应或者近似阳明病的症状反应。

“胁下硬满”，是典型的少阳病的症状反应。

“不大便而呕”，这是两个不同的症状，其中“不大便”就是指的多日不解，一般情况下，会认为这是阳明病的症状，但是当它与少阳病的症状反应同时出现的时候，这也是少阳病的症状反应。实际上，这也是这个条文论述的一个重点。也就是说少阳病里边，完全可以出现大便不通的情况。那么“呕”，在这儿肯定就是少阳病的症状了。

“舌上白胎”，指的这个舌苔较常人偏于厚，而且色泽还是白色，就是白的接近于常人。那么在这儿，这个苔象重在强调什么呢？在强调既有里实又有里热，但是程度都比较轻。如果里热重了，或者里实重了，都会出现苔黄这一类的舌苔。

那么主要的病理，还是少阳病的问题。所以这儿呢，“可与小柴胡汤”。有商量的余地，没有用主之。如果里热再重一些，比如舌苔黄，人潮热得厉害，就有用柴胡加芒硝汤的机会；如果里实再明显一些，就有用大柴胡汤的机会。

实际上在临床当中，这一类的病人还都是挺多见，好多年轻的女孩子，常年手脚凉，然后长期大便不通，食欲不好，人也瘦，状态也不好，但是又不怎么感冒，好多这样的。像这一类的病人，你去问问她，常常都表现一些柴胡证。

接下来，“上焦得通，津液得下，胃气因和”，这是古人对小柴胡汤方剂和它的适应证在病理方面的一些认识。小柴胡汤的主药是柴胡，《神农本草经》对柴胡有这样的论述：“治心腹，去胃肠中结气，

饮食积聚，推陈致新”。在经方理论中，柴胡证常常有胸胁苦满，胁下硬满这类的症状反应。如果按照现代医学的研究，这一类的症状，大部分都属于一些炎症。像胆囊炎，肝炎，甚至些肺炎等等。古人的认识，就认为这是结气。“上焦得通，胃气因和”。就是服了小柴胡汤后，人体在病理上的变化。古人对“胁下硬满”这一类的症状，通过服小柴胡汤，它消失了，就认为是结气得通了。

同时，小柴胡汤所有的药物，都有改善胃肠功能的作用。所以“胃气因和”，也是小柴胡汤一个很主要的功效。

但是“津液得下”，这是这个作者的认识。至于说小柴胡汤证，是否是津液积滞于胸胁，这值得研究。如果说的是的话，咱们刚刚学过第 229 条当中，小便是正常的，那么在体液代谢正常的情况下，出现了大便溏，仍然可以用小柴胡来治。如果真有“津液得下”这个因素存在的话，那么这个下利就不会好，不单单不会好，而且有可能还会加重。因为“津液得下”嘛，本来胃肠里边水分就多了，再加上胃肠功能不好，有点儿虚，再补充津液，下利的程度不就更重嘛。另外呢，小柴胡汤几乎所有的药物都有改善胃肠功能的作用。所以这里的不大便，应该是里虚而且有热所造成的，而不是消化道内津液不足所造成的。所以这个地方，我觉得值得推敲。

“身濈然汗出而解”，这是服小柴胡汤后，出现病愈的一种暝眩反应。第 101 条是这么论述的：“凡柴胡汤证而下之，若柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却复发热汗出而解”。把这两条联系起来解读的话，就会发现，在人体偏于虚证的情况下，服了小柴胡汤以后，就有可能出现“汗出而解”的这种情况。这应该是什么啊？应该是这个条文的作者的临床所得，这是实际的临床经验。这儿的“汗出”，并不是小柴胡汤有发汗的功能，而是人体在较为虚弱的情况下，服了小柴胡汤之后，所出现的愈病的征兆。这就像表证一样，表证本来就应该发汗，发汗解表，汗出则愈。但是很少有人去想另一个问题，

麻黄汤证没有服麻黄汤，或者发汗太多，这个病都不能好。为什么服了相应的发汗药，出汗太多，表也没有解？从这可以看出汗出，并不是表解的唯一的标志，只有在方证相应而且汗出适度的情况下，才可以解除表证。这说明汗出而解，只不过是条件的证候，并不是一定要达到汗出。那么“身戢然汗出而解”也是这么一个道理。服小柴胡汤不一定有汗出，但是有这种汗出而解的这种情况，特别是有先发热后寒战，最后出一身汗。凡是这样的病人，要么是长期患病的，要么就是人特别虚，实际长期患病的，实质问题还是一个虚的问题。那么我呢，有时候我跟病人是这么解释，实际我也是这么认识的。有些很虚弱的小孩子，典型的叫抗生素婴儿，这类孩子看他也没有精神，吃也不行，小孩子也黄黄的、瘦瘦的，或者精神特别不好、又哭又闹的这种。他感冒常常离不开小柴胡汤，而且可以在小柴胡汤的基础上合上其他方剂，有热合上麻杏石甘汤，或者合上桂枝汤，合上其他的方剂。你给他治的过程中，常常会伴有发热，发热以后汗出，汗出而解。真是这么个样子，但是前提条件就是虚。

大家想想这是个什么过程啊？其实就是人体的内部状态改善了以后，抵抗力在增强，就形成了一种提高体温的机制，造成那些外界的致病因子在体内不适应，所以随着汗排出体外。就是造成不适合那些外界致病因子存在的一种状态。

阳明病、中风^①、脉弦浮大、而短气、腹都满、胁下及心痛、久按之气不通、鼻干不得汗、嗜卧、一身及面目悉黄^②、小便难、有潮热、时时哕、耳前后肿、刺之小差、外不解、病过十日、脉续浮者，与小柴胡汤、^{（231）}脉但浮、无余

症者、与麻黄汤、（注）若不尿・腹满加哕者・不治・③（232）

注：

1. “阳明病、中风”《宋本》作“阳明中风”。
2. “一身及面目悉黄”《宋本》作“一身及目悉黄”。
3. 《宋本》此处有“麻黄汤”三字。其后有麻黄汤方及方后注，此从略。

胡希恕：（音频缺如）

阳明中风，即太阳中风转属阳明。弦为少阳脉，浮为太阳脉，大为阳明脉。腹都满即上下腹俱满，为里有水气。胁下及心痛，指胁下及心下俱痛，属少阳证。久按之气不通，指按其胁下和心下稍久则觉气息窒塞，呼吸困难。鼻干属阳明证。不得汗即不得汗出，属太阳证。嗜卧属少阳证。一身及面目悉黄，小便难，为黄疸病。有潮热，时时哕，属阳明证。耳前后肿属少阳证。

由以上的脉和证可知，此为三阳并病而又并发黄疸者。刺之小瘥，谓用针刺治疗，耳前后肿已稍微减轻之意，但仍不得汗出而外不解。病过十日而脉续浮者，可与小柴胡汤治之。若脉但浮而无余证者，则可与麻黄汤。至于黄疸病，虽以利小便的方法治之，而仍不尿，腹内水气不消，故腹满有增无减，并加哕甚者，则胃气大衰，故不治。

【按】本条是黄疸而现三阳并病的重症，治从少阳而用小柴胡汤。麻黄汤之用，实想不通，可能有错简。实践证明，黄疸型肝炎并发腹水者预后多不良，谓为不治不为无据。

【注】

①太阳中风本有自汗，但本条为黄疸病而现三阳并病的重症，在传变的过程中变为无汗。若有汗出，热得外越，还不至于到一身及目悉黄的严重程度。

②小便难为里有水气，水热互结于里，故发黄疸，一身及目悉黄。

③有潮热为阳明证，时时哕乃水结于里，外不得汗，小便又难，气不旁通，故时时上逆而哕。

④耳前后肿属少阳病，一般孔窍部位炎症以少阳证居多。

【按】小柴胡汤亦治黄疸，加橘皮治干咳或哕逆，加石膏治腮腺炎及淋巴腺炎，用之屡验。据明代赵开美本，本条自“脉但浮，无余证者，与麻黄汤”，以下单列一条。即使如此，据脉但浮而用麻黄汤亦不可解，有待后学研究。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格排版的条文。

条文中的“阳明病中风”，在《宋本》里没有“病”字，《宋本》是“阳明中风”；“一身及面目悉黄”在《宋本》没有“面”字，就是“一身及目悉黄”。在《宋本》条文的最后有“麻黄汤”三个字，并且在条文最后附有麻黄汤方剂以及方后注解，在《康平本》里没有。另外，这个条文在《宋本》里分为两段，“与小柴胡汤”之前为第231条，之后为第232条。这些东西校对的话，应该是区分开来的，但是作为学习来说，几乎所有这些变化都能说明问题。我们这一次以《康平本》为底本，对照《宋本》来学习，我们可以得到更多的信息，可以更加准确地理解经方理论。

解读一下：

先看第231条这部分，“阳明病中风，脉弦浮大而短气”。《宋本》中把“阳明病”的“病”字给去掉了。是传抄过程中的遗漏，还是特意去掉的？现在没法下结论。这样的改动以后，实际上就成了“阳明中风”，“阳明中风”是什么？大家看一看在第190条里有“阳明病，能食者”就是阳明中风了，就变成食欲比较好的阳明病了。再看看《康平本》的原文是“阳明病，中风，脉弦浮大”，如果再参照条文后边的各种述症，实际上这个地方指的是三阳合病，而不是那个食欲偏于旺盛的阳明病，再说后边的论述的症状明显的就是少阳病。但是为什么用了比较笼统的概念来论述呢？这里边有原因，通过后边的学习就可以明确的体悟到，实际上就是阳明病和太阳病的证候都不够典型，因为有治疗方剂在这儿，所以在这儿就没有列举具体的症状反

应，仅仅是用了一个“脉弦浮大”。我们学习《伤寒论》已经学了百分之五十以上了，大家已经对经方的理论有明确的概念了，就是说实际临床中的表现不一定仅仅就是“弦浮大”的脉象，原文的作者把这种脉象作为一个典型的脉象放在这个地方，是有用意的，就想说明这是一个三阳合病。“弦脉”一般就是少阳，出现在少阳里边比较多；“浮脉”太阳病里边比较多；“大脉”在阳明病里边出现的机会比较多。但是我们再看后边的各种述症，症状基本上都是少阳病的症状反应。咱们一点一点地来分析。

“短气”。这是一个具体的症状了，咱们把它移过来：“短气，腹都满，胁下及心痛，久按之气不通”。整个这一组症状是以胸腹部为主要的，“腹都满”跟阳明病里的“腹满，甚至腹满痛”，这儿也不一定不痛，学到最后就清楚了，它不是因为里实证造成食积之满。“胁下及心痛”，“胁下”不用说了，“心痛”这个心不是指的心脏，而是指经常说的心口、胸口处，在医学上就是指剑突这个部位附近有疼痛感。因为有腹满、胸胁部的病变，所以造成有短气感，呼吸就感觉到不顺畅。如果长时间地按压胁部或者上腹部，患者就会有窒闷的感觉，觉得喘不过气来。也就是条文里的“久按之气不通”。

接下来“鼻干，不得汗，嗜卧，一身及面目悉黄，小便难，有潮热，时时哕，耳前后肿”。这一部分是非常明显的少阳病的症状。但是大家要注意，它没有特别典型的少阳病的症状反应，它实际上是说在少阳病的病理状态下发生了黄疸，以及在这种情况下常见的一些症状反应。

为了好理解举一个例子，比如柴胡桂枝汤，有时候在临床病人表现的既没有典型的小柴胡汤证，也没有典型的桂枝汤症状，病人表现为阵发性的出汗。对经方理论理解得比较到位的，对阵发性出汗解释得会非常好，但是好多对经方使用不熟的人碰到这种情况，他想不到会用这个方子。像许多更年期综合症，停经前后患者容易出现类似的

症状，其它什么症状也没有，觉得一切都挺好，就是阵发性的出汗，有的是下半夜天快亮的时候呼呼出一阵汗，而且出的量特别大，有的是吃饭或打电话的时候会阵发性的出汗，患者既没有口苦，也没有往来寒热，更没有发热、恶寒了。就是既没有典型的小柴胡汤症状，也没有典型的桂枝汤症状。但是像这类没有典型症状的时候，用柴胡桂枝汤特别好用。实际真正分析得深的话，它有症状，比如“发作有时”应该是少阳病的症状反应，阵发性的出汗，桂枝汤有类似的论述，“时发汗、时发热”这类也有。这两个加在一块，在临床中表现出来是一种很奇特的情况，但这两个方剂的典型症状都没有。

这个地方也是这样。当以小柴胡汤为基础病理的时候，如果发生黄疸，它表现出来的这些症状没有典型的小柴胡汤证。像这些症状看着不太像少阳病，但是又算不到别的病里。咱们觉得拿不准的、不容易判断的症状逐个地来看：

其中“小便难”，有人就说这一段所论述的，绝对不是小柴胡汤所能治得了的。“小便难”，小柴胡汤怎么能治得了？其实小柴胡汤的或然证里有“或小便不利”，可能会出现这种情况的。发生黄疸本身就是一种比较特殊的情况，在这种情况下小便不利的程度会重一些，但是它基础的症状反应还是以少阳病为主的。至少按这个条文论述的，“小便难”还不能把它看做水证，它应该是少阳病的症状范畴。

另外一个“有潮热”，关于潮热前面的学习过程中已经讨论过了，潮热既是阳明病的症状反应，同时又是少阳病的症状反应。这么多的少阳病症状摆在这个地方，它就应该以少阳病为主了，应该归到少阳病里边，其他的症状“时时哕”、“耳前后肿”了都是典型的少阳证，包括“鼻干、不得汗”都可以算是少阳病的症状反应。现在把它偏于少阳病的这一面，充分分析了以后还不能忽视另一面，尽管这些症状都可以算做少阳病的症状反应，但是它比较偏于里热，偏于水证，就是说它偏于体液代谢不好，偏于有阳明里热的成分。这两个因素恰恰

是形成黄疸病的条件，它列举的这些症状，这种味道非常得浓。所以，顶格条文的作者常常是用症状、方剂、脉象来说道理，把道理都蕴含在这些里边。把上面这些症状总结了一下，它都可以视作是少阳病在发生黄疸病的时候，容易出现的一些症状，我们可以把它叫做易发症。换一句话说，小柴胡汤证当发生黄疸的时候，它的症状反应与小柴胡汤本证有一些明显的区别，区别就是这些述症里边，包括上面我们说的胸胁部的那些症状，也都一样。

再接下来，“刺之小差，外不解；病过十日，脉续浮者，与小柴胡汤”。这儿的“刺之”，指的是其他的医生用针刺的方法治疗，治了以后只是症状稍微有点缓解，所以说“小差”，但是表证没有任何缓解的迹象，这里说了“外不解”。那么又过了十余天以后，病情仍然维持着“刺”之前的状态，换句话说，那个“小差”只是短时间的，后来的表现跟针刺之前基本上是一样的，所以就仅仅用了一个脉象来代表，就是“脉续浮”。这个作者有时候会用一些比较简略的词，没有用“续弦浮大”，只用“续浮”表达了一下，“续”的意思是说脉跟以前的情况差不多，言外之意是说证跟以前也差不多，不然就没有用小柴胡汤的依据了，光凭一个脉浮，怎么可以用小柴胡汤呢？从“针刺”之前的述症看，这个条文的作者绝对没有使用“刺法”的可能性。因为后面，他主张对针刺之前的这种情况用小柴胡汤来治，他起初就不可能亲手用针刺的方法去治，所以这个“刺之”是指别的医生治的。如果经过针刺十多天的时间以后，前症已经基本消失了，仅仅剩了脉浮的话，也就没有用小柴胡汤治疗的必要了，所以这个“脉续浮”就是指的前证基本上还都在，还是以前的情况。

这个条文的腹证详实而且复杂，不单单是明文列举的这么多症状反应，还有一些没有做详述的，某些像阳明病和太阳病的证候，都在条文的开始用病理的方式隐含在里边了，而且同时还有明显的体液代谢不良的因素。对于这么复杂的病情，虽然主张用小柴胡汤治疗，但

说得也比较客观，是“与小柴胡汤”，用了有斟酌余地的这种阐述方法，明显的意思是治疗要以小柴胡汤为主的。为什么这么说呢？如果结合临床，像这样的病人来找我们看，凡有临床基础的人都可能会想到用小柴胡汤合上茵陈蒿汤，如果水证再重的话，也可能会考虑小柴胡汤合五苓散。但是凡有黄疸者，一般的首先想到的就是茵陈蒿汤。条文里特别强调的小柴胡汤证的一些症状反应，就是说出现了这类症状的时候，千万不要单纯的用茵陈蒿汤来治，要以治疗少阳病为主。这也没有脱离经方的治疗原则。

我们再拓宽一点思路。如果我们把这个条文和《金匱要略》中的“黄疸病脉证并治第十五”中的相关条文结合起来解读，就会辨得更清楚，更容易理解。那里边第二十一条是这么论述的：“诸黄、腹痛而呕者，宜柴胡汤”，后边有注解：“必小柴胡汤，方见呕吐中”。这是《金匱要略》里的条文，虽然述症非常简，但仍然能够明显地看出所论述的情况，与现在学习的这个条文情况非常接近。按照经方理论的论述特点，正是因为《伤寒论》对这条做了如此详尽的论述，所以在《金匱要略》里它就从简了，其实这两条所有的述症，都是可以互为补充的，所以刚说的“腹都满”也未必没有腹痛。因为在《金匱要略》里有论述“诸黄、腹痛而呕者，宜柴胡汤”，“呕”就跟这条里的“时时哕”非常相似了。另外，现在学习的这条的所有症状，都可以出现在《金匱要略》“诸黄”之后，所以这两个条文应该互参。这样我们就可以整体地来理解：当以少阳病，也就是以半表半里的虚热证，再合并里虚证的病理状态下，一旦发生了黄疸病的时候，大概人体的症状表现，有什么样的特征说得就很明确了。这是第 231 条。

下边是第 232 条的部分：“脉但浮无余证者，与麻黄汤。若不尿，腹满加哕者，不治”。

因为在《康平本》它和第 231 条是同一段，这一段应该接在“病过十日”之后，不是“续浮”了，是“脉但浮”。就是说针刺之后，

有过小瘥的情况下，过了十余日之后，针刺以后主要的症状都消失了，病通过针刺以后治好了，就只剩下一个脉浮。如果按照读经方的读法，后面有麻黄汤，就很可能又出现麻黄汤证了，不仅仅是脉浮，而且有发热、恶寒，成了另一种情况，仅余表证了，就用麻黄汤来治。从字面上和文字结构上看，应该这么理解。但是如果从它的论述内容来分析，这个地方有很多不当的地方。

第一，是从针刺之前的述症看，经过针刺以后出现麻黄汤证的可能性非常小，几乎是不可能的事。那么繁杂、严重的病，甚至都发生了黄疸，通过针灸，过了十来天自己就好了，这是不太可能的事。而且条文里有明确的表述，针刺以后仅仅是小瘥，没有起多大作用。

第二，即使是针刺以后过了十余日，人有自愈的倾向了，即便是这样，出现麻黄汤证的可能性也不大。麻黄汤证是比较浅层次的表实证，一般情况下，得了这么大的病，恢复时间不多长，又出现麻黄汤证的可能性非常小。

我们在之前，关于王叔和两次整理这本书做过详细地论证。对比《康平本》和《宋本》的这两个条文，我们会发现王叔和在第一次整理这本书的时候，整理成《康平本》的样式，这两段是同一段；到了第二次整理的时候，他又把第 232 条单独划出来，列为一个自然段。从这个变化中可以感觉出来，不仅仅是当时的王叔和感觉这个地方文义不能衔接，而且很可能有更深层次的原因。什么深层次的原因？大家都知道，这个书是失散以后王叔和重新搜集整理的，肯定是他一手把这本书重新编在一起的。他在重新编辑整理的时候，很可能不知道第 232 条这一段该放在哪儿，就感觉到放在这个地方比较合适，第二次整理的时候又感觉不合适，想起第一次整理的时候，这段也不是在这个地方的，干脆就把这一段单独地又列成了一段。当然，这样说没有根据，只是猜测可能有这方面的因素存在。我们做这样地分析，就是想说明一个问题，这一段放在这儿，很多地方感觉不合适，特别是

内容上和上一段无法形成一个逻辑性的对接。这个地方我主张存疑，很有可能有错误、有错简，或者本来这段文字就不在这个地方。

阳明病自汗出、若发汗、小便自利者、此为津液内竭·虽硬不可攻之^①、当须自欲大便，宜蜜煎导而通之、若土瓜根、及大猪胆汁、皆可为导、（233）

注：“虽硬不可攻之”《宋本》作“虽硬不可攻下之”。

蜜煎方

食蜜七合

右一味、于铜器内、微火煎、当须凝如饴状、搅之勿令焦着、候可丸^①、并手捻作挺、令头锐、大如指、长二寸许、当热时急作、冷则硬、以内谷道中、以手急抱、欲大便时、乃去之、已试甚良、疑非仲景意·

注：“候可丸”《宋本》作“欲可丸”。

又大猪胆一枚、泻汁和少许法醋、以灌谷道内、如一食顷、当大便出宿食恶物、甚効、

胡希恕：他说阳明病本来他是自汗出，那么若再发其汗，这个津液亡失太多了，啊，小便又复利，那么这样子啊，造成这个大便干呐，啊，这是由于这个津液丧失太多了，“此为津液内竭”呀，啊。这个，人身上这个体液呀，夺于外，他内脏器它这个水分也被夺，这个胃肠里头水分也被夺。所以这津液在…在这个胃肠里头也枯竭。这就使着大便硬。这一种大便硬啊，它不是由于这个阳明病这个热结造成的，“虽硬不可攻之”，言外就是不要…不要吃承气汤这一类的药，啊，大承气汤更不能用了。“当须自与大便”，啊，那么这一个呢，啊，

就让他自己大便下来，想法子。“蜜煎导而通之”，蜜煎导这是一个法子，或者用土瓜根，或者用大猪胆汁，全可以，啊，导此大便出来的。后头这几个法子啊，就是近乎现在咱们这个灌肠啊，西医灌肠的法子，这是一样的。那么这一条啊，根据我们头前儿讲过，啊，阳明病本自汗出，啊，复发汗，你看头前有那么一节儿，是吧？啊…是多少条我看看呐，你们回头看一看，啊，在这儿呢，203 条儿，你们回头看一看，203 条儿，阳明病，本自汗出，医更重发汗，病已差，尚微烦不了了者，此必大便硬故也。以亡津液，胃中干，故令大便硬。当问其小便日几行，若本小便日三、四行，今日再行，故知大便不久出。今为小便数少，以津液当还入胃中，故知不久必大便也。这一节儿啊，就承着这一节儿说的话。那一节儿说是这个，啊，本来他自汗出的，阳明病它是自汗出啊，啊，那么若再重发其汗，啊，那一个说的呢，它不是小便自利，它说是小便呐，啊，当时日三、四行，那么现在小便少了“日再行”，这一个津液它逐渐恢复，所以这个，这个…这个津液呀，应该还要还入胃中的，那一个 大便它就，就出来了。那么这一节儿呢？它不是。意思是一样的，也是本自汗出而又发其汗，这个小便呢？而“反自利”，它不是一点点少，这一个它不能自还的。这一个，就是上边它是一半，说了一半。那么如果小便要是自利怎么办呢？这个就根据那一段，小便自利，这也是津液内竭，使着大便硬，也不能攻啊，是吧。他这，就是这样子。那怎么治疗呢？啊，想法儿让这个患者呀，“自欲大便”，啊，就是用一种这个，啊，这个灌肠，啊，这一个引导的办法。那么底下这几个方子呢，你们看一看。先说的这个蜜煎导。就是食蜜，啊，他是用的七合，那么这一味药啊，“于铜器内微火煎，当须凝如饴状”，啊，就像那乱呼呼的那……（音频缺如）……“欲可丸”，啊，我们观察呀，这个可以做成丸的时候，就拉倒了。“并手捻作挺”，啊，就是做一个，啊，啊…一个挺，啊，就是膏状的。令这个头儿啊，锐，啊，比较尖，大如指。就像这个，

人手指头这么样子，啊，就指着大拇指了。“二寸许”，长二寸许。这个二寸许呀，古时候这寸没有现在这个寸大呀。“当热时急作”，在这个蜜热的时候你赶紧作，它一凉就要硬了嘛，“冷则硬”。以内谷道中，以手急扞，欲大便时乃去之，啊，他要大便的时候了，啊，你不要拿手捂着了，是吧？那么底下他说“疑非仲景方”，这一个是不对的。这个是，根本是他这个书里头的。“已试甚良”，疑非仲景方啊，仲景意呀，这在这个成无己那本没有，在《玉函经》也没有，这是后人搞… 搁……搞的，啊，他注的。这一个不要，这几个字。那么，啊，“已试甚良”，那么这个经过试验很好。还一个法子，用这个大猪胆汁，这一个更好，啊。这一个我也试验过。“猪胆汁一枚”，就这个猪胆呐，整个猪胆，这么一个，把那个汁啊，泻出去一部分，泻汁，和醋 少许，以灌谷道内，啊。把这个汁子啊，倒出来搁这碗里头，啊，他这原意是这样子，啊，加上少许醋，完了往谷道里头灌。这个灌，古人有这么个法子，就用这一个猪胆，这个原来那个猪胆，那个猪胆呐，把这个汁啊，稍倒出点儿，灌上点儿醋，啊，在里头把它搅和好就行。他古搁竹子，就是咱们那个，那个毛笔那个笔管就行，啊，插到猪胆 里头把它卷结实。就，啊，把那个头儿啊，抹点油啊，或者蜡呀，啊，纳入肛门呐，就是，一撮这个，这个猪胆这个…它就能灌下去，这也是个法子，啊。如一食顷，当大便，啊，那么就是，灌上猪胆一小时就真要大便的了。这一个还是好处，啊，这一个，啊… 这个猪胆这个灌肠啊，比我们现在搁那个肥皂灌肠还是好点儿。另外一个呢，他说一个土瓜根。这个土瓜根就把那土瓜，那个根儿啊，也把它削了， 啊，它那个东西也有粘滑性质。然后把它蘸成蜜，纳入谷道，也是一个样，跟那个蜜煎导差不多。那么这就说这个大便硬啊，也得看情形，不是大便硬就得吃大承气汤，不是的，他没有大实，大满，大痛，热，啊，他不是由这一种情况造成的。所以这个辨证啊，不光看证候，而且要看当时这个病情，啊，他怎么造成这个大便硬。

这也挺重要的，啊。这 种的泻，人是绝对要虚的。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降一字格排版的条文。

“虽硬不可攻之”，在《宋本》是“虽硬不可攻下之”，没有什么原则的问题。

下面我们解读一下：

“阳明病、自汗出”，指的是近似于白虎汤证的阳性里热证。患者有某些里热证的症状反应，同时又以“自汗出”为最明显。这儿主要的问题是什么？他没有里实证。

“若发汗”，阳明里热证，本来应该清热，发汗等于是误治了。而且本段条文论述的就是“汗出”比较明显，再施以汗法，必定会严重地损失人体的津液，这里边应该有深层次的问题。像“自汗出”，“若发汗”，不应该包括桂枝汤类方剂，因为明显的阳明里热而汗出的这种情况，你用了桂枝汤类方剂发汗的话，不仅仅是一个大便硬的问题了，还会出现别的变证，病情会加重。

“小便自利者”，比“小便自可”应该是偏于量多，是由于里热，人体机能偏于亢奋，一方面有汗出，另一方面小便的量也比常人要偏多一些，这本身就形成了一个体液损失比较多的局面；那么在这种情况下，再施以汗法，就会使人体的津液陷于一种虚损的状态。

这儿旁注“此为津液内竭”，是做的病理解释，加在这个地方，对于理解原文的论述，非常精道，确确实实可以帮助我们理解原文的本意。

“虽硬不可攻之”，在这种情况下，出现的大便硬而不通，应该是很自然的事，原因就是津液虚，消化道里边津液都因为里热而排出体外了。所以这儿的“大便硬”不是真正的里实证，更不是里实热证所造成的。虽然从症状的表现来看，他既有热证，而且还有汗出、小便频数，貌似里实证，但是它的病因还有另外的因素，就是误治了以后体液损失太多。所以没有里实证的这种病理环境，纯粹是因为津液

虚造成的。所以这种时候不能使用攻下的方法。

接下来“当须自欲大便”，这句话在这个条文当中，有非常重要的意义。如果没有这一句话，那上边的所有这些论述，完全可以理解成他经过误治以后形成了里实证。但是“当须自欲大便”，换句话说，这个病人得有大便的那种感觉，在这种情况下，那才是这个条文里边所论述的证候。

它的意义：

第一，是患者有大便的自我感觉，而且这种情况不是吃了泻下的药出现的，是“自欲”，是自己想大便，说明胃肠功能基本正常，大便硬仅仅是因为津液虚。

第二，暗示我们与其他类似的方证加以区别。比如，承气汤之类的方证，虽然里实证严重，他也大便难，但是他大部分多日都没有要大便的自欲感。都是腹满、腹痛、难受，但是没有便意。另外麻子仁丸证，更是多日不大便无所苦，尽管条文当中没有这样论述，但在临床当中确确实实就表现为：很多天甚至半月二十天不解大便，也不觉得特别难受；跟承气汤不一样的地方，没有腹满、疼痛，他没有便意，压根就不想解。

第三，有自欲大便的感觉，当解的时候又感觉困难，这个地方是应用本条文所论述的这几个方剂的一个重要指征。所以这句话在条文里面是非常重要的。

接下来“宜蜜煎导而通之，若土瓜根及大猪胆汁，皆可为导”。上边学过的这些论述，给出了三种治疗方法。大家看一看这个方剂的制作方法和用法，就知道这都是直肠给药，所以适应证基本上是大同小异。这也就没有做进一步地论述。

这个条文论述的三个方证的病理，基本上都是一样的：就是虚热证合并了水虚证（津液虚）。

因为，条文本来的意思就是用于这种误治以后所造成的急性的短

期的病症。所以条文里面并没有对这三个方剂之间的区别做进一步地论述。但是根据后世对这一类方剂的实际应用经验，在临床当中，这三个方剂的应用范围，比条文的论述还要宽一点。这三个方剂里面，除了土瓜根导，书中没有详细地论述，再一个胡老说的比较详细。但在实际应用当中，土瓜根首先得有这个东西，咱们现在用的土瓜根饮片，都是特别干，切的一片一片的，没法用。得是鲜的，跟手指头差不多粗，一段一段的，得是鲜的才好用呢。所以这个临床医案就比较少。

其他的两个方子，都有临床应用的实例，从这些实际临床应用来看，蜜煎导同时有一些补益的作用，所以比较适合这种单纯因为津液虚，并且人体体质也偏于虚弱的这种情况而发生的便秘。比如老年人、儿童、体弱的出现便秘的情况。

而猪胆汁导，实际是猪胆汁和醋的复合方，在通便的同时，还能振兴人体的机能，还可以清热润肠。那么比较适合哪一类呢？从临床实践看，比较适合手术之后出现的便秘，产后出现的便秘，像麻痹性的肠梗阻等。这一类的共同特点：或是重病，或是有外界的因素，造成了人体机能的沉衰，出现比较严重的便秘。

那么土瓜根，从药性上去分析，它是一个寒性祛瘀的药，有去瘀血的作用，所以比较适合于里热而伴有瘀血症，同时伴有津液虚的这种便秘。

我们为什么去分析这个？随着社会的变迁，这一类的方剂给人一种简单、落后、麻烦这么一种印象。所以现在临床当中，应用的机会都非常少，很少有人在用。但这些方子，临床疗效远远比现代医学那些灌肠、开塞露之类的方法要好得多。比如最易让人接受的开塞露，是人为地给肠道里面加润滑剂的方法，来改善便秘的情况。它仅能解决这个问题。但是对人体来说，它绝对没有像蜜、猪胆汁的药物作用，是绝对没有的。而且中药这些方法，不单单可以达到解决问题，治疗

这一类疾病的目的，而且同时还能祛病。像蜜煎导如果想用的话，是随时可以做的。凡是这一类的临床医案，用对了疗效都非常好，而且疗效持续的时间比较长，用上一段时间，很长时间就不用再用了。实际上这是药物起的作用，灌肠之类达不到这样的效果。

关于方剂的制作与应用，方解里面说得非常清楚，咱们就不再细说了。大家自己看一看，有兴趣的可以在临床上试一试。

另外这一类的方剂，还有这个剂型，有进一步完善的余地。比如蜜煎导，制药厂里可以出，这样就免得做的时候麻烦。这个蜜经过炒稠，适合做成栓剂，如果在这个基础上加一些相关的辅料，不用炒制使它达到那个状态，做成栓剂，可以长时间的保存，用来说不定比开塞露要好或是更方便一些。

阳明病、脉迟、汗出多、微恶寒者、表未解也、可发汗、宜桂枝汤、①（234）

注：《宋本》此处有桂枝汤方及方后注，此从略。

胡希恕：这个“脉迟”这是个不足的脉了，啊。所以在仲景这个说，就是这个营虚血少脉迟啊，啊，那么也就是津液不足，是吧？“汗出多”，这个汗出多就影响这个津液虚嘛，啊。但是还“微恶寒”，这表还没解，啊。既要表未解，这根据他这个书啊。里实应该下，但是他这个里实还不显呢，啊。但是有了阳明病的外观了，所以他冠之以阳明病仁字。那么只是表没解，我们应该先解表。但是里虚，里虚寒的病，表里同时有，我们要先救里的，啊。这都是定法。这咱们在太阳篇都讲过了。也就是在阳明病，如果表不解，要是汗出，啊，而脉缓弱或者迟，这都是桂枝汤证，所以这一阵儿还用桂枝汤以解外。这桂枝汤咱们头前儿讲过了，不必细分析了。

李冠杰：这条在《康平本》是降两字格排版的条文。《宋本》在

这条后面有桂枝汤方及方后注解，《康平本》没有。

解读一下：

“阳明病”出现在条文里是错误的。在这里我觉得有必要做一个小的说明：大家不要看到降两字格的条文就想方设法的找毛病，看到顶格的条文就去歌颂、去捧场，应该客观地来看。我在对待降两字格条文的内容上，尽最大的可能汲取有用的东西。因为咱们从古人那里能够接受下来的真正“上古”的东西，就这么一点儿。但是，如果真正把降两字格条文内容加到一块儿，说句不好听的，批判还来不及呢。你去看看“伤寒例”里的那些东西，对照《康平本》把所有确认是降两字格的条文集中到一块儿，你就会发现：降两字格条文的作者不是经方理论体系里的人，理论上不是这个体系的。

顶格条文也有不对的地方，前面也有，不对就是不对，讲不通就是讲不通。两三千年了，别说有什么客观原因，就是没有什么客观原因的话，古人有认识不到位的地方，我们现在能把它纠正了，那也没什么不好。我们下次学习大概就有吴茱萸汤证，那个说属于阳明，无论如何也讲不通的。

这个“阳明病”在条文里就讲不通。这论述的不是阳明病。为什么说是阳明病呢？因为汗出多嘛，汗出多了以后就有可能造成大便硬或者大便不通这类的情况，就是有这些症状存在，就把它错误的界定为阳明病了。咱们整体解读阳明篇里这些降两字格排版的条文，就会发现这个作者对阳明病的界定，确确实实有以大便不通为标准的倾向，虽然不都是这样，但是确实有这种倾向，阳明病开篇那几条就非常明显。但是在这条中，如果将汗出多和大便不通这样的症状界定为阳明病，就成了原则性的错误啦！为什么呢？它下边有述症呀。

“脉迟”，是阳明病的机会就少了，虽然不能完全杜绝它是阳明病，但问题是后边还有治疗方剂呢！“脉迟”就是脉动次数比较低，这个地方它不是阳明里热的脉迟，当然大承气汤还有可能出现迟脉

的，但是这个地方绝对不会是那个。这个脉迟后头是：或津虚、或血少、或者是里寒、或者是虚，至少是表虚证，或有里寒或说是津液虚。在这儿津液虚的可能性是比较大的，因为汗出多嘛。再从治疗方剂上来看，这儿有一个问题，像这个作者往经典里加这样的条文，必然是他在临床中有所验证，不会毫无依据的往里加。换句话说，就是他在临床实践中有用桂枝汤治好的这种经验，他碰到的病人有大便硬、汗多的，就认为是阳明病，用桂枝汤治好啦！实际上这不是阳明病患者，是一个表虚证患者，而且从汗出多看，偏于桂枝加附子汤证的情况，就是表虚比较厉害的这类情况。

“微恶寒”，那就更证明不是阳明病啦，这是一个地地道道的太阳表虚证，而且他自己也说了“表未解也”，还存在着表证。作为对这个条文述证的定性，说“表未解也”应该是有问题的。但是跟阳明病的论述结合到一块儿，本身就含有太阳、阳明合病的意思。我们前面学习过，太阳阳明合病的有些情况下，需要“先解表，后攻里”，但不是他说的这种情况啊！实际上他就是出于对这种理解上有偏差，才这样行文的。进一步延伸就成了太阳阳明合病，有汗出的情况，还有“恶寒”的情况，可以用发汗的方法来治，具体的发汗方剂还是桂枝汤。就等于说，太阳阳明合病的情况下可以用桂枝汤先解表啦，就成了这么意思。像这个条文，后面还有近似的条文，降一字格的条文里也有这样的论述。

这种论述，就是造成后世认为“桂枝下咽即死”这种情况的源头！因为人们看了条文以后，认为桂枝汤也可以治阳明病，太阳阳明合病的时候就可以用桂枝汤，真要是太阳阳明合病的时候，要真用桂枝汤就麻烦了！严重了确实能死人。记得胡老说过一个人，因为发热，就老给他发汗，最后人就死啦，胡老去的时候也晚了，没法治啦。

桂枝汤属于温性的解表方剂，如果有阳明里热的情况下，即使是存在表证，无论是表虚证还是表实证，都没有应用这个方剂的机会，

实际上既有表证又有里热的方证多的是，像大青龙汤、麻杏石甘汤等等，但没有一个用桂枝汤的机会！这个条文实际上就是一个单纯的桂枝汤证，本来他治也没错，述症也没错。但是因为看到了患者有大便不太好解，然后汗出也比较多，就界定成了阳明病，后来他总结出这样的条文，并加在经方的书里，就对正确解读经方造成了严重的误导！以致于今天还有人在走这样的路。这说明条文的作者对经方理论的理解有误，他的理论不是经方的理论体系。

阳明病、脉浮、无汗而喘者、发汗则愈、宜麻黄汤、（235）

胡希恕：前边这一节儿说的是太阳中风转属阳明的；这一节儿呢，就说的太阳伤寒转属阳明了。这一个都可以说是太阳阳明了，啊。“脉浮，无汗而喘”，这是个表实，啊。脉浮为在表啊，这个无汗而喘，应该再在外，再在表，所以发汗就好，啊，这当然用麻黄汤了。那么虽然他冠个阳明病，这是由太阳病传阳明，但是，啊，表证还明显，表不解，那你还得先解表。那么有汗，啊，脉虚，要用桂枝汤；无汗，脉实，啊，当然要用麻黄汤了。

李冠杰：这个条文也是个降两字格排版的条文。

咱们解读一下：

“脉浮，无汗而喘”，再加上治疗方剂，“宜麻黄汤”嘛，就明确无误的说明这儿论述的就是太阳表实证。冠以阳明病，从这个作者的理论观点来分析，这儿的“阳明病”也应该指的是“大便不通”这一类的症状，但是这儿不仅将麻黄汤证，错误的定性成阳明病，而且其后还有“发汗则愈”，这句话就更了不得啦，就是说他有这样的论述，等于说是在有麻黄汤证的情况下，如果同时还存在着阳明里热证，甚至是里实热证，可以用麻黄汤来治疗。给你交代原则了，“发汗则愈”嘛。这就跟经方理论大相径庭，在有表证同时又有里热的时候，

经方里边相关的方剂很多，像麻杏石甘汤、大青龙汤、厚朴麻黄汤、越婢汤等等，绝没有单独用麻黄汤来治疗的可能。

如果再多一点佐证，在实际临床统计资料数据当中，咱们找到的140多个麻黄汤证的医案，这140多个医案当中，没有一个有大便不通之类的症状反应。如果这个条文当中的阳明病，不是指大便不通而言，那么这个条文述证的完全就是一个麻黄汤证，阳明病也就无从谈起了。我们猜测它的阳明病，可能的依据，也就是说便秘这个症状，其实临床当中也没有，它这个阳明病哪来的呀，这个条文本身基础就成问题了。所以说这个条文和第234条一样，不足为信。这里就是一个桂枝汤治桂枝汤证、麻黄汤治麻黄汤证这么简单的一个事，扯不到阳明病的事。

阳明病、发热汗出者、此为热越·不能发黄也、但头汗出、身无汗、剂颈而还、小便不利、此为瘀热有里①·渴引水浆者、身必发黄、茵陈蒿汤主之、（236）

注：“此为瘀热有里”《宋本》作“此为瘀热在里”。

茵陈蒿六两 梔子十四枚擘 大黄二两①

注：《宋本》此处有“去皮”二字。

右三味、以水一斗二升、先煮茵陈、减六升、内二味、煮取三升、去滓、分三服、小便当利、（注）尿如皂荚汁状·色正赤·一宿·腹减·黄从小便去也·

胡希恕：“阳明病”，这是里热的一种证候了。“发热汗出者”，啊，这一个热越于外呀，这一个不能发黄的。“但头汗出”，只是头出汗，啊，那么身无汗。这个“剂颈而还”呐，在这《玉函经》就是“齐”，就是看齐的那个齐。这个大概古人呐，这个“齐”和“剂”

通用，啊。就是只脑袋有汗，一到这个颈项这儿，就没汗了。齐于颈项，齐于颈项这以下就无汗了。“小便不利”，啊，热既不得越于外，而小便又不利，这个水又不得泻于下，他又“渴引水浆”，啊，又嗜饮，这个水，这里头当然有停饮了。这一个…热瘀于水，啊，湿和水是一样了，古人叫瘀热，这一个热瘀于里头，啊，那一定身要发黄的，这是古人一种看法。那么这个黄疸病啊，他古人认为是，啊，是胃肠疾患。怎么个疾患呢？啊，有湿有热，瘀于胃肠之里造成的。这是古人的看法。那么现在的这个黄疸呢，咱们，啊，离不开这一个肝胆的疾患了，尤其胆，是吧？啊…尤其这一个，啊，胆道受阻碍等等的吧。那么古人虽然这个看法有些问题，但是对这个治疗啊，古人的确是这一种治法，它有效。你像我们这一个方子吧，茵陈蒿汤主之。这个茵陈蒿汤啊，茵陈是个利尿药，也解热，它是一个苦寒、利尿、解热；栀子、大黄都是苦寒药物，都是去热的药物。所以这个药的组成看，它是去热，啊，利湿。那么根据这个，中医说瘀热在里呀，对于治疗这个…这个手段是相符合的。那么这…是不是由于瘀热在里而发黄疸呢？这是值得，啊，我们研究的。当然不是，是吧？这一个有很多证明嘛。那么但是发黄疸，他常是瘀热在里。这一个发黄疸，古人这个东西它总是有热，啊。而且发黄疸常常小便不利。这一个，我们在临床上，啊，不断遇着这个事情。那么可见那个古人的看法虽然有错误啊，但是这一个，临床的这个实质是这个样子。在黄疸的时候啊，他是，啊，瘀热在里的；可这个病呢，不一定从瘀热在里造成的，是吧。那么这一个，所以中医呀，我说多少次了。他这个规律法则，他是通过实践的，啊，这是多少年也不会错的。那么至于这个解释的方法，那就不一定了，是吧？所以我们这个…对于这个书啊，总是要有这么一个，啊，正确的对待它的一个态度。就是他这个方法、方式，这是肯定的；那么古人的这种解释，有些错的。那么这一个，关于这个黄疸就是这样子。古人他认为这是，啊，湿与热相瘀，啊，这一个脾受

了蒸，啊，就是脾胃了，因为这个脾胃这个色儿属于土，应该黄，一蒸，他就发黄了，这是古人的看法儿。这种看法是幼稚的，这一个，啊，不一定是对的。但是这个病既发黄了，他是要有热，要有…要有湿。小便不利嘛，啊。所以这个治疗非常确当。那么古人也就，兴拿这种现象当了本质了。就是这个事儿。所以我们研究这个古人的东西呀，必须要有这么一个认识才行的。要不古人怎么说怎么是，这也是错的，啊。所以咱们研究它，取其精华嘛，去其糟粕嘛。科学证明的东西呀，我们就不要…啊…咱们还是要…啊，说是就是瘀热…啊，造成的，啊，不是这个胆…啊，这个输胆管发什么障碍，这是瞎扯谎，这不行。嘿，嘿，嘿！实质上不是这个事儿。

李冠杰：这段条文在《康平本》是顶格的条文。

旁注：“此为瘀热有里”，在《宋本》是“此为瘀热在里”，恐怕是传抄过程中的手误。

咱们解读一下：

“阳明病”，在这个条文当中，主要是指阳性里热证而言，这个地方依然是没有明显的实证。

那么“发热汗出”，是阳明病的症状反应。在这儿呢，指一般的阳明病而言，类似于白虎汤这一类的。像这一类的情况，“不能发黄”，这个“不能发黄”，就是在阳性里热证同时又伴有发热、汗出这一类情况的话，人体是不会发生黄疸病的。

“但头汗出，身无汗，剂颈而还”，指的只是头部有汗出，颈部以下及其全身都没有汗的一种症状。那么临床当中也有表现为无汗的，也有只是手足出汗，身上没有汗的，也有这种表现的。情况虽复杂，但是实质都离不开一个原则问题，这就是有里热。他本人发热汗出的话这是正常的，但是这儿呢，没有出现那种局面。而是出现一种什么呀？虽然有里热，但是又汗出不畅。他要是汗出通畅的话，不至于仅仅是头汗出，或者是手足汗出，甚至也没汗，就是汗出不畅，这

也是一种病态。

“小便不利，渴饮水浆”，这是典型的体液代谢不良的反应。那么这儿的“渴饮水浆”，与猪苓汤证的口渴、五苓散证的渴，在病理上是相同的。都是因为废水不得去，影响新水的吸收，而造成组织缺水这么一种症状反应。

“身必发黄，茵陈蒿汤主之”。这儿这个“必”，应该当做“可能”来解读，不要解读成“必然”。因为有时候阳明病，甚至有小便不利的，不发黄也有得是。这个“发黄”，就是指的黄疸病了。

事实上，这个条文不单对茵陈蒿汤证典型的症状反应进行了论述，同时还阐明了湿热瘀于里，是黄疸病重要的发病机制之一。

在这个条文里边有两处旁注内容，一个是“此为热越”，另一个是“此为瘀热在里”。这个很明显地强调了里热证是造成黄疸病的一个重要因素，但是却忽略了水实证的因素。为什么说这个？如果翻一翻《康平本》的竖排原始的版本，这个“此为瘀热在里”，加在“小便不利”和“渴饮水浆”之间的，是加在这个地方的。加在这个地方，仅仅是“瘀热在里”。这说明什么？这就说明这个旁注的作者，对于“湿”同时也是造成黄疸病的一个重要因素的这个问题，至少是强调得不足。现在很难说他没有理解到这一层，但是他至少是没有强调这个事。你都加在这个“小便不利，渴饮水浆”边上了，仅仅是说了一个“瘀热在里”，这有点不全面。

茵陈蒿汤证的病理：是半热证合并里实热证，再合并水实证。

做个小结：阳明病如果表现为发热汗出的，因里热得以散发，一般情况下不会发生黄疸病；如果只是头部有汗，颈部以下及全身不得汗出，同时又伴有小便不利，渴饮水浆的，则可能会发生黄疸病，此为茵陈蒿汤主治之证。

再来看一下这个黄疸病，它是有着明显特征的一个病。中医辞海是这样定义的：黄疸是以面目身肤熏黄，小便黄赤为特征的疾病。那

么黄疸病这个症状特点，跟其他疾病的症状明显不同。因为这个病，它的症状反应和病因，都不相同，还可以分为若干不同的类型。

在《伤寒论》有几个条文论述，在《金匱要略》有专门的一个章节在论述。那么这个条文论述的是什么？论述的是以“湿热瘀于里”为主要病因的一种黄疸病。这种黄疸病，是临床当中比较常见的一种。它的发病机理：里热证与体液代谢不良，这两个病理因素互相作用的结果。

咱们现在看看里热证。人体不管什么原因，出现了不正常的亢奋状态。在这种状态下，人体代谢过程明显得加快，结果，不仅仅会产生过多的体内热量，同时还会产生过量的代谢物。所以人体要维持体内的正常环境，便会用加快体液代谢的方法，一方面散发体内的这些热量；另一方面，又通过或汗或小便，排出过度亢奋产生的代谢物。这也就是里热证通常会表现为：汗多或者小便多的原因。糖尿病不就这样吗？有三多证的糖尿病，他吃得多，喝得多，尿得多，也常常表现为出汗多。在这种状态下，他是不会发黄的。因为他体内代谢物，都通过小便及时地排走了，所以他不会。但是人体的患病，不是一种状态，里热是非常复杂的状态。如果人体出现汗出不畅，他可能就会增加尿液的排出，用这种方式来代偿；如果小便不利，他也可能会增加发汗的方式来代偿。但是汗出和小便排出的机制都出现障碍，就形成了热不得越，就形成这么一种局面。一方面有热，另一方面体内的热量和大量的代谢物又没法正常地排出体外。

凡是黄疸病，都有小便黄赤的问题。刚才说的“小便黄赤”就是这么来的，就是这个机理。这是能从题外看到的，我们现在能够看到的这一部分，只是问题的一个面。更重要的是什么？更重要的是，如果有“小便不利”，或者再加上“汗不得出”的话，含有大量代谢物的黄赤的液体，就会滞留在体内，随着血液流遍全身。首先就会在最薄弱的某个器官积聚起来，而呈现黄色。比如，有人会先眼睛发黄，

后来慢慢地再浑身发黄，如果再严重了，就发展成全身性的。这也就是这个条文里边论述的“身必发黄”的由来。

再去看看方后注解，这段注解内容就非常得好：“尿如皂荚汁状，色正赤，一宿腹减，黄从小便去也”。这个地方说得就非常得好。就是造成黄疸的这些东西，从小便里边排出去了。那么反过来呢？得黄疸的时候就因为应该排出去的而排不出去，形成的黄疸嘛。

咱们以上分析的，就是形成黄疸病的一个主要的原因。虽然，黄疸病不都是因为湿热造成的，有的因为血分，还有别的病机，但是这个原理是错不了的。它最终要形成这样的机制，人才可能会出现黄色。不然的话，那黄色哪儿来呀？那个古人那种解释“脾色必黄”，那是不着边际的，不对。

茵陈蒿汤咱们在分析方剂的时候，会跟大家说一个比较独特的观点。

下边看看方解。茵陈蒿汤由三味药物组成：茵陈蒿、栀子、大黄。茵陈蒿是个寒性的，有清热利湿的作用，同时能去黄；栀子也是个寒性的，解热除烦，也有去黄的作用。大黄跟这两味合在一起，就能起到增强祛湿祛热祛黄的力量，能够增强这种药力。

那么，从药物用量上来看，茵陈蒿是主药，它所对应的病理，就是因湿热而造成发黄这一类的病。但是有这一类功能的药，不仅仅是茵陈蒿，能够清热同时又能祛水的药非常得多，但是治疗黄疸，其他的药都不行。就说栀子，既能清热解烦，又有一点祛水的作用，而且也能祛黄。跟茵陈蒿的功能，就非常接近了。但是这个方剂如果仅仅是用栀子和大黄的话，那绝对治不了这个病，这毫无疑问啦。

下边我们看看茵陈蒿汤证的症状反应：

身黄、小便不利、纳呆、便秘、发热、腹满、恶心、乏力、口渴、胁痛、身痒，这是出现频率比较多的。频率稍微低一点的：厌油腻、神疲、头晕、口苦、浮肿、夜卧不宁。这些，都跟湿热有关。

值得注意的是什么？总共统计到了 171 个医案，条文论述的“但头汗出身无汗”，仅仅出现了 5 例。说明什么？虽然这不是一个非常典型的症状，但是，在说明病理上，它能起到这个作用。比如，纳呆排在第三位，出现了 108 例，出现频率就相当高，但是它说明不了湿热在里面的病理状态。所以说，我们读经方不要死读。为什么经方有人背得滚瓜烂熟，但是疗效不好。就是他能进去，但是出不来，那也不行。

舌质：红舌、淡红、暗红、淡舌、绛舌、尖红、燥舌。

舌苔：黄腻、薄黄、深黄、白腻、黄燥、黄厚、厚腻。

脉象：弦数、滑数、弦滑数、弦滑。

茵陈蒿汤证对应的现代疾病：急性黄疸性肝炎、急性肝炎、慢性肝炎、慢性传染性肝炎、病毒性肝炎、甲型瘀疸型肝炎、亚急性肝坏死、肝损伤、黄疸、肝损伤性黄疸、急性胆囊炎、慢性胆囊炎、胆石症、化脓性胆管炎、胆道蛔虫、高胆红素血症、婴儿黄疸、荨麻疹、血吸虫病、沟端螺旋体病、胃肠炎及溃疡、十二指肠溃疡、阑尾炎、肥胖症、急慢性盆腔炎、脂溢性皮炎、接触性皮炎、大叶性肺炎、多发性口腔溃疡、急性结膜炎。值得注意的是，这里包括了好多皮肤病，用茵陈蒿汤来治疗皮肤病的机会挺多，但是，他得有这个病理状态。

阳明证、其人喜忘者、必有畜血、所以然者·本有久瘀血·故令喜忘·尿虽难^①、大便反易、而^②其色必黑者、宜抵当汤、下之、

③（237）

注：

1. “尿虽难”《宋本》作“尿虽硬”。
2. 《宋本》无“而”字。
3. 《宋本》此处有抵当汤方及方后注，此从略。

胡希恕：“阳明证”，啊，就是大便干的。他搁个证，他没说是阳明病，啊。“其人喜忘者”，那么这个人呐，“喜忘”就是“好忘”，啊，咱们现在说是“好忘”，啊。那么可见这个瘀血呀，与这个脑系是有关系的。你看那桃仁承气汤，咱们说这个抵挡汤也有啊。其人如狂，其人发狂。所以，与脑神经的这个，啊，这个不正常，啊，是很有关系。我就根据这前后这些条儿，对于脑系疾病，啊，我治了很多。都是用祛瘀的法子很…很有效。所以这个地方也是，他喜忘，跟那个如狂，啊，这都是脑…啊，啊，都是大脑的病啊，是不是。“必有蓄血”，必有，蓄血者就是久蓄之瘀血呀，啊。那么“所以然者”，就是本来他有久瘀血。他平时啊，潜伏这个瘀血呀，它不显。那么由于，啊，得了阳明病，那么这一个，这个热与这个瘀血，啊，它结合起来，它就要发作了。因为有久瘀血，就是指着蓄血说的了，所以他才喜忘。屎虽硬，啊，大便反易呀，这一个，这个血，大便里有潜血这是说的了。这个血它是润，啊，那个大便本来它是硬的，但是有血这种这个润在里头啊，你虽然硬，但是大便的时候并…并…并不费劲，反容易，可是这个色儿必黑，啊。这是血的色了，啊。这个血，这出来之后没当时便出，它本来就黑，这搁在现在说就是潜血了。这一个可以用抵挡汤下之，用承气汤是不行的，必须下其血。那么由于这一段，我们可以看出来两个问题：头一个问题呀，就是脑系的这个，所谓神经状态的这个异常，常常有瘀血证，这是第一；第二呢，凡出血症，你看这个他是，啊，大便潜血了，我们讲桃仁承气汤也有，啊，所以“血自下，下者愈”，凡是出血症，有很多是由于瘀血的。所以咱们遇着这一种，啊，啊…出血症就止血，这个事儿也很耽误事啊，啊。有很多的是瘀血，你不去瘀，他这个瘀不去，他出血不止的。咱们讲那个《金匱要略》，啊…那个妇科呀，就有这么一段，他说妇人妊娠呐，啊，下血不止，他说这一个，这一个病啊，就是这个寻常的有…就是有久瘀血，那也是有瘀血。这个平时，这个妇人呐有癥，啊，“癥者”

就是一个血的…血的积块。她这个癥不去，血不止，所以他用桂枝茯苓丸，啊。那么下其…啊，下瘀，消灭这个癥，自然她就不下血了。这很多了，啊，这是在书里头。我们在临床上，也的确这样子。我们治这个失血证啊，总要看看这个…当然这个虚证你是用这个法子是不行了，只要是实证，大概祛瘀药相当…相当有效的。那么这一段也提出这些问题来了，他本来他大便…他大便色儿黑，那就是下血嘛，啊。起码他是潜血，而且潜血他是很重了，这色儿要能看出来黑。那你再去瘀，啊，不但他这个喜忘可以治，而且他这个潜血也可以治的。所以这个地方，我们读这个古人书 啊，不是说这一段就在这一个病，应该再这样儿，应该扩展发挥它的作用，你得从这里头认识，你不认识不行的。这个抵当汤在头前也讲过，啊，这个方子，啊，不必作细解了。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格排版的条文。

条文中的“尿虽难”，在《宋本》中是“尿虽硬”；“而其色必黑者”，《宋本》中没有“而”字。《宋本》在条文最后附有抵当汤方和方附注，《康平本》中没有。

我们解读一下：

“阳明证”，应该理解为虽然有阳明病的某些症状反应，但是它不是主要的病理因素。这地方挺怪，用了一个“阳明证”，没有用“阳明病”的论述。

“其人喜忘，必有蓄血”，这儿阐明了一个非常重要的医学概念，就是人的记忆力与血液方面的疾病有密切的关系，也就是说“瘀血证”是造成记忆力下降的一个重要原因。这在几千年以前的古代，除非是经过临床实践总结，凭那个时候的技术能力是没法认识到这类问题的。咱们现在虽然有一点认识，但还是拿它没办法。

旁注：“所以然者，本有久瘀血，故令善忘”。强调了瘀血证都不是短时间内形成的。所以说“本有久瘀血”，这儿解释得比较好，

其他的文字就有一点可有可无。

“尿虽难，大便反易，而其色必黑者”。这个“尿虽难”，从字面上看指的是小便难，但是从文义上、内容上分析，它跟后面内容不能衔接，这个地方肯定有错误。但是《宋本》中这地方是“屎虽硬”，反而比这个“尿虽难”更恰当一些，跟后边的前后呼应。这个地方论述的是大便偏硬、偏干，但患者反而没有排出困难的感觉。这个时候大便的质地一定是黑色的，“必”字可以当做“必定”来理解。这实际上就是说，人体消化道内部出血的一种情况，由于出血的部位偏于消化道的内部，所出的血和大便混在一起，也就是和肠内的内容物混在一起，最后排出的时候就变成黑色的。可是又因为有里热存在，大便中的水分又偏少，就形成了一种黑色的硬便。但是因为便中混有一些瘀血，血液本身能够有润滑的作用，所以解大便的时候，反倒是不像便秘那样难以排出。

下边是“宜抵当汤下之”。这儿用“宜”字，没有用“主之”，就是说有变通的余地。原则上说，这类既有里热又有瘀血的合并证，应该用下法来治疗，这也有“下之”。但是具体的方剂也可以去变通，得看患者的症状表现，比如根据症状的不同，像桃核承气汤、下瘀血汤，甚至包括桂枝茯苓丸都有应用的机会，得符合这个方证。

用下瘀血的方法来治疗出血，初看似乎与常理不通。血像水一样从破损的地方流出，最好的办法是堵住它。为什么反倒是让血的浓度再小，去祛瘀？在经方医学里，常常用清热、祛瘀的方法来治疗这类疾病。但不是见到出血，就用清热的方剂，像大黄黄连泻心汤可以治很多形式出血，像衄血、吐血之类的都有应用的机会，但是它得有那个方证。

这个都是来自于临床实践的经验，这类出血的机制以前也简单地说过，或是因为热，或者因为瘀血，它造成局部血管内的血压短时间内发生急剧升高，就是说或者血流太快造成堵塞，或者是因为有瘀血

的情况造成局部形成了过高的血压，一些浅表性的血管承受不了，就会出现破裂，就会有出血证。所以，这个时候用止血的办法，不但不能治愈，而且还可能会加重病情。

对于瘀血证根据什么用呀？瘀血证的辨证条文里说得也非常清楚，典型的症状反应就是“其人喜忘”，其他条文里也都有论述，比如“其人如狂”之类的论述。但是不管怎么样，用清热祛瘀的方剂，人必须得有热有瘀，这是一个根本。有热有瘀的证据是什么？还是症状反应，所以说方证相应是经方医学的不变的一个原则。经方理论对出血有没有用补的办法治疗的？有。那些因为血虚造成的出血证，就用补血的办法止血，比如黄土汤证、胶艾汤证、当归芍药散证都属于这类的。

关于因为瘀血而致人“喜忘”，甚至发生精神方面“其人如狂”的疾病，现代医学通过现代科学的研究也有所认识，研究发现所谓的瘀血，就是人体内的血液在质量方面出现了偏离正常状态的变化，其中有一部分血液的状态已经不是正常的血液，失去了正常血液的功能，附着于血管壁上不参加循环了。当时间长了以后，这些等于是坏死的血液积累得越来越多，这就是瘀血了。这些东西久而久之会发生变质，质变的过程中会产生一些有害物质，随着新鲜血液流遍全身。研究发现，这些有害物质虽然对人体的其他器官正常功能影响不大，但是对大脑和精神方面的功能影响非常严重，轻者记忆力下降，重者会发生精神失常的这种症状。具体的现代医学书上说质变以后产生氨气，是不是仅仅氨气的原因也很难说。现代医学可能就认为是这个原因，但是这个认识的过程，认识的机理，对我们理解经方在临床中得出来的经验确实有用，能够吻合，这也就是一种进步。虽然现代医学有了这样的认识，却拿瘀血证几乎毫无办法，到现在没有什么真正好的办法。但是中医治这个可以说是强项，比较专长，像现在一些老年痴呆症什么的，都有用祛瘀的办法治疗的机会。

阳明病下之、心中懊憹而烦、胃中有燥屎者、宜大承气汤、（注）若有燥屎者·可攻·腹微满·初头硬·后必溏者·不可攻之·（238）

注：《宋本》此条文如下：

阳明病，下之，心中懊憹而烦，胃中有燥屎者，可攻，腹微满，初头硬，后必溏，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤。

胡希恕：那么大承气汤用啊，是多…多方面的，啊。所以我们关于这个每一节儿啊，都要细心体会。他说阳明病本来吃泻药下，那么虽然下之，这个人心中还懊憹而烦。这个懊憹而烦呢，这是承气汤与这一个栀子豉汤，是共有的一个证候，你这非细辨不可，啊。那么假若我们能够诊断他胃中有燥屎，那还可与大承气汤攻之。那么由下面“腹微满，初头硬，后必溏，不可攻之”这一句话，我们怎么知道为什么有燥屎呢？当然了，他要有一种特殊证候那没问题了，你要发潮热而谵语，这是有燥屎，啊；发潮热，手足濇濇汗出，也可以能知道，啊，大便硬了。那么现在他没有这些证候，这又他又给你指出一个，就是腹微满与不微满，就是大实大满而且拒摠，这是实啊。那么在《金匱要略》有这，也有这个，这个腹满，按之痛者为实，按之不痛者为虚。那么大下之后心中懊憹，也是，可以说是胃里头什么都没有，这叫虚烦；那么如果他有燥屎呢，他也有这个心中懊憹；那就得呀，没有其他的证候了，就得做腹诊，啊。那你摠摠这个肚子，如果胀满的利害而且拒摠，他疼啊，那肯定这是有燥屎，我们还可以吃大承气汤。否则，只是微满，初头硬，后必溏啊，微满这里头也有点屎，但是它是初头硬，后必溏，这一种大便，这不是一个实，啊。这万“不可攻之”，那么言外呢？应该用栀子豉汤。“若有燥屎者”，啊，他又是叮咛一句话，宜大承气汤。所以这个心中懊憹而烦，我们不要片面看问题。所以这个片面看问题，在临床上这是个危险的事儿啊。心

中懊恼，啊，这是，咱们就是…用烦热的一个状态了，一般是栀子豉汤时多，但是他有燥屎呢？也有这个情形。所以要全面掌握啊，有燥屎，栀子豉汤就没用。可是栀子豉汤证吃大承气汤呢，那就坏了，啊，那非虚其人不可。所以这个地方啊，啊，这一个方证之辨呐，所以必须得讲。而且人也得理解了，在临床上才不能够出错误。那么以下这几段都是，都用大承气汤，啊，这一种这个辨证的说法了。

李冠杰：这条在《康平本》里边是顶格条文。

《宋本》把注解内容窜入正文，做了一些改动：“阳明病，下之，心中懊恼而烦，胃中有燥屎者，可攻。腹微满，初头硬，后必溏，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤”。这个地方改动得比较大。

但是这个地方也能证明像这样的问题，有人说：《康平本》是在《宋本》的基础上改写的，像这种情况，没人能改出来，没人能把《宋本》这样的情况，把他调整了以后，改成两部分，一部分是注解，一部分是原文，没人能做出这种事来。所以说真的东西假不了。

下边解读一下：

把这个条文跟第 221 条参照着解读的话，可以帮助我们全面准确地理解这个原文的本意。第 221 条说了一大堆的阳明里热证（没有里实证）的症状反应，又论述了发汗以后会出现什么情况，加温针会是什么情况，下以后会出现什么情况；其中下了以后“胃中空虚，客气动膈，心中懊恼，舌上胎者，栀子豉汤主之”，要用栀子豉汤来治疗。对于阳明里热证，经过误下以后，所产生的变证与咱们现在学的第 238 条比较近似，但是他们之间有着虚和实的区别，一虚一实。第 221 条是阳明病当中因三种误治情况，都是误治了以后出现虚热证，尽管症状反应有些特殊，但是还都需要用栀子豉汤来治。

这个地方，“阳明病，下之”，就是下后，“心中懊恼而烦”。虽然它是阳明病，但是使用了下法之后，不但没有愈，而且出现了新的变证。这就说明这儿的阳明病也是没有里实证的里热证，所以使用

下法就是误治了。“心中懊恼而烦”，其实就是典型的栀子豉汤证，这个要用栀子豉汤来治。但是除此之外，他还有其他的变证，条文里边怎么论述的？

“胃中有燥屎者”，本来是里热证，但是误下了以后，不单单里热没有解，而且还发生了里实。这儿有两点，咱们必须得清楚：一个是这个地方出现胃中有燥屎，必定是在下法之后，数日之内形成的，不会是下了之后马上出现的。本来就是一个里虚证，里边就不实，下了之后怎么可能马上就形成里实证啊？最起码那些东西要吃进去吧，所以说这是数日以后的事情。但是这儿的“胃中有燥屎”，必定得有一系列的阳明里实热证的症状反应，得有症状，但这地方没有说，下边咱们会进一步地解析。第二，我们都有这种常识，下法通常会造成，比如下利不止，特别是对于虚证，会造成里虚寒证。但是下法有时也可能造成里实证，这个条文就是论述这种情况。这个“胃中有燥屎”，本身不是论述一个症状，严格地说，这是一个病理。

这就变得非常耐人寻味了，它比较独特。这个条文论述的是阳性里热证误下以后出现了大承气汤证的这种情况，但是条文当中的述症，没有一个是明显的大承气汤证的症状反应，仅仅是笼统地用了一句“胃中有燥屎者”，来说明了病理特征。实际上这就是一种避实就虚的论述方法。怎么叫避实就虚啊？

下面，咱们一点点分析：这个时候的患者，他有明显的栀子豉汤证，可是条文里论述得很清楚，这个病不能用栀子豉汤来治，这里强调的是：不可以用的症状，把栀子豉汤证的这个“心中懊恼而烦”，反倒是明确的提出来加以强调。意思就在于要读者明了这个时候，尽管有这个症状，但是同时它还有严重的里实热证，应该用大承气汤，而不应该用栀子豉汤来治，后边跟你说得很清楚。

所以我们说它是避实就虚的论述。尽管有栀子豉汤证，但是因为里实热证已经形成，已经比较明显了，“胃中有燥屎”嘛。你千万不

要用栀子豉汤来治了，要用大承气汤，这就是这个条文论述的重点。

至于说“胃中有燥屎”的这种大承气汤证的症状反应，其实在其它条文里边多有论述了，这儿就仅仅以病理来代之。我刚才说它避实就虚，也就是在这个意义上。因为大承气汤是一个急危重症，这个时候没有再用栀子豉汤清半表半里的虚热和里热的机会了，再晚了，就有可能出现危险。所以说这个地方就给强调了一个特殊情况下，应该遵循的一种特殊的原则。

这个“心中懊恼”跟第 221 条的“反谵语”，咱们再联系起来解读一下：也就是当里热证误治以后出现虚热证的时候，他有栀子豉汤证，虽然有“谵语”这样的栀子豉汤证以外的承气汤证这种症状，不是说“反谵语”嘛，也不能用承气汤来下。因为它是一个虚证，我们能通过这儿来佐证，明确第 221 条实际上是这个意思。这一条出现的“心中懊恼”，也是同样性质的问题，同样是里热证经过误下了以后出现了大承气汤证的时候，虽然有虚热证的栀子豉汤证的症状反应，也必须用大承气汤来治，都互相佐证的。

另外，我们从临床统计资料看，大承气汤证没有“心中懊恼”一症。大承气汤证方证统计的是比较详细的，没有一例出现心中懊恼这种症状的；而栀子豉汤证也没有一例出现谵语的。我们客观地说，出现这种症状的机会非常非常得少，这个地方论述的都是一些特殊的情况，不能拿经方里其他的论述来佐证这个地方有“谵语”，这就不是栀子豉汤证了，他强调的恰恰就是，这是特殊情况，这一点非常重要。不然的话，真要是临床当中碰到此类问题就容易出错，但是道理我们得懂，如果懂了，就可以举一反三。

通过学习这条条文，我们就能体悟到经方医学它就是一门来自于临床实践的医学，它一切都是围绕着临床实践为中心的。所有的原则都不是一成不变的，不同的情况要不同的对待，一切都要以临床实践为准则。

比如当表里同病，里证属于虚寒的时候，要以里证为主；而当里证属于实证的时候，有可能用到先解表后攻里；但是里实证达到了大承气汤的这种危重的程度，矛盾的主次关系就发生了质的变化了，其它的都不重要了。我们再往后学就有好多急下证，就是得急下。虽然说那些条文大部分都不是顶格条文的内容，但是它必是来自于临床实践的经验，那都是不知道用多少人命换出来的，血的教训。所以说这儿都是我们应该注重的一些，如果理解不到这个层面，对经方理论的理解就不能算到位。

病人不大便五六日、绕脐痛、烦燥^①、发作有时者、此有燥屎、故使不大便也、（239）病人烦热、汗出则解、又如症状、日晡所发热者、属阳明也、脉实者、宜下之、脉浮虚者、宜发汗、下之与大承气汤、发汗宜桂枝汤、（240）

注：“烦燥”《宋本》作“烦躁”。

胡希恕：239条：这个“燥屎”与“大便硬”还有点不同啊。这个“燥屎者”，就这个屎存在的日子相当的多，由于它“燥”横在里它不下，这谓之燥屎，啊。这个大便硬啊，就是应该排出大便，由于他硬排不出去，啊。这一个可以说它在下面了，是吧？这个燥屎则不然了。燥屎，宿食，啊，都是似相通，而实质上有分别。所以燥屎，大便硬和宿食，全有用大承气汤的机会，啊。他这个，我们怎么样子来辨认它，那么这一个就是有这么一段。他说这个人不大便，啊，五六天之久，绕脐痛，啊，这个，围之…围绕肚脐呀，发疼痛。而且烦躁，烦躁就是有热吗，啊。“发作有时”，一阵一阵的，时疼时不

疼。这说明什么问题呢？他那个燥屎横在里头它不通，欲通不能。可是欲通，它涩滞在肠子里头，它要一动他就疼得不得了，所以他就发作疼痛啊。可是它愿意…不行，啊，这个…这个大便往下行，这肠子蠕动啊，往下催，嗯，一催这人疼得不得了；有时候他也不欲大便，啊，它不行…不行他也暂时就不疼。所以他是发作有时呢。这个大便要行，他就疼，哎，它不要行…也暂时他也不疼。所以他是发作有时。这种情况，啊，根据外来的症状啊，这是有燥屎的一个证候。那个当然用大承气汤。这是又是一个。有几天不大便了，那么这个人叫呐，绕脐痛，啊，发作有时，这肯定他是有燥屎，是大承气汤证。

240 条：“病人烦热，汗出则解，又如疟状”应该是个“复”字，啊，“复”，在这儿当“反”字讲，啊。“复如疟状”，这是什么，这是这个《玉函经》上的，啊，他后边有注儿，这个应该改个“复”字。“日晡所发热者，属阳明也。脉实者”，这个“宜下之”啊，在《玉函经》也是个“当”字，“当下之”。脉浮虚者，当发汗，下之宜大承气汤，不是个“与”字，发汗宜桂枝汤。他这个改个“当”字可以，不改也行啊，这都讲得通，啊。他改个“当”字呢，因为他下边他用的“宜”，他古人这个用字啊，啊，他念着也顺口，啊，原来大概总是个“当”字，啊。这个问题都不大，改不改都行，啊，都能讲。但是这个“又”字，不如“复”字，“复”字是“反”，当“反”字讲。那么病人发“烦热”，你们想一想，这个“烦热”指着什么说的？这个是指着大青龙汤证说的。咱们头前儿不讲嘛，太阳中风，是吧？脉浮紧，发热无汗，身疼痛，不汗出而烦躁者。一般的这个表实证啊，他不怎么烦躁的，他有热啊，他是。不汗出而烦躁，所以他底下搁个“汗出”。也就是大青龙汤证不汗出而发烦躁，啊。那么用大青龙汤，达到汗出，那么他这个就解了，它是这么来的。可是解是解了，“复如疟状”啊，反而他就变了这个病。像发疟疾似的。指着什么说呢？指着这个发热有定时，“日晡所发热者”，日将暮的

时候他发热。那么这一个时候的发热属阳明也，这是属于…啊，转属阳明证了。脉实者，当下之。这一阵儿要看看他的脉，如果脉实，那肯定这是由表传里了，应该下。脉浮虚者，当发汗。那么这一个呢，还是表不解了。这一个根据什么呢？咱们头前儿讲了，时发热，啊，汗出者，宜桂枝汤。他也是定时发热，这个日晡所发热呀，啊，这个桂枝汤证也肯定在这一个时候每天发热，他定时发热，而要汗出，那是桂枝汤证。那么这一个日晡所发热呢，又属阳明，那么在这一个，这是两方面都可能的，啊，那么这…这…这…这就得辨之于脉了，脉沉实而有力，肯定这是传里了，那就得泻。脉还浮，他还是在表嘛，虚他是经过大发汗了，用的大青龙汤了，啊，他津液不足了嘛，那当然还是桂枝汤证嘛。所以脉浮虚者，啊……（音频 028 完）（音频 029 始）……就在上边这两句话，“病人烦热，汗出则解”呀，这个病啊，它来势猛峻的很呐，方用了大青龙汤，大青龙汤它是，啊，内以清热，外以解表这么一个方剂，发汗也相当的重。那么这个药方吃下去，这个表将罢而就传里，这一个病啊，这是急剧变化，啊，正在变化莫测之时啊，这稍要是一缓呐，是变证百出啊。所以这个治病啊，不但要辨证，还得审…详审当时病情，这就是。一般说就日晡所发热而已，还没发潮热呢，啊，那不能用大承气汤。但在这一个情形之下，那是不得了的。他由于大青龙证，用完大青龙汤了，反而就传里，你看看这个病，这是正在…啊，急剧发生变化之时啊，这应该与大投通剂，所以他用大承气汤。这一个你往后看那个急下就知道了，这个病来势猛暴。所以这一个在临床上很不容易呀，尤其这个地方，啊。第一个问症啊，要详细，你不问他，怎么知道吃大青龙汤了，是不是？那么我们个人治病当然心里头…心里头明白了，旁人治的病赶上这个时候找你来了，你不详细问就不行，啊。这个脉实、脉虚它是个对待，这个实啊，啊，实而有力，就是脉跳动也有力，啊，这谓之实，跳动无力者就谓之虚，啊。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降一字格排版的条文。

条文当中的“烦躁”是“燥”，在《宋本》是个“躁”，这个应该是对的。

下边也简单地解读一下：

这两条条应该存疑，为什么呢？下边咱们简单地，慢慢地去品。我在这儿简单地列出几个理由：

第一个，如果按照《康平本》的样式来解读，那么这个条文为同一段内容，但是所论述的内容，却存在着前后不相顺接的问题，前后不太通。这也正是王叔和第二次整理的时候，把它分成两段的原因，肯定是，毫无疑问。本来“故使不大便也”之前的论述，应该是后文当中使用大承气汤的一个见证，要不然的话，何以用大承气汤。前边最起码还有点靠谱，因为不大便嘛。但是后边论述的这个治法与这个内容不相衔接，因为它还有别的嘛。特别是后边条文内容当中有什么样的论述啊？像“病人烦热”，这个“病人烦热”明显的跟前半段条文病人有烦躁，这不就等于重复了嘛。如果是一个人写这么一段内容的话，不会出现这样的重复。那么就有可能这两条条原本不是在一起的，或者说有其他的什么，这是一方面的原因。再一个就是“汗出则解”，“汗出则解”更是跟上面的论述不相吻合了。这么严重的，都出现大便硬的情况了，再去发汗，而且还汗出则解，就不太通了，所以说前后的内容不能呼应。

第二个，如果按照《宋本》的样式来解读，第 239 条就变得没有什么意义了。你要是视为有燥屎的述症，他就为了说明燥屎是怎么来的。要如果是为了说明这个呢，其实这一类的说明在其他条文早就有论述。而且他行这么一段条文，又没有治疗方剂，这没有实际意义，既跟其他条文重复，又没有治疗方法，这就没有意义了。如果把它视作是不大便的病因，你在强调病因，也没有专门立这么一段的必要，其实这个条文里边就有“绕脐痛”这一个症状，有一定的实际的临床

意义。

再看看第 240 条，如果作为一个单独的段落，他所论述的这些情况，应用大承气汤和桂枝汤的证据都不充分。从字面上解读就能看出来。这是一个什么啊？单从字面上看实际上是一个近似于大青龙汤证，或者说比大青龙汤证更侧重于里证的这个情况，他不是说“汗出则解”嘛。而使用了这一类的方剂治疗之后，表解了，但是里热不除。即便是出现这样的情况，仅凭一个脉象，都不能成为应用大承气汤和桂枝汤的使用指征。表也解了，仅凭这么一个脉，就用大承气汤，这是说不通的。那么应用桂枝汤呢？这儿有“日晡所发热者”，“日晡所发热”是典型的阳明病的症状反应，在这种情况下，如果这个脉要浮虚就用桂枝汤，那也不可以，这也没有应用桂枝汤的机会。

所以这个条文的原貌是个什么情况？这个 240 条以前是不是接在 239 条的后边？239 条后边还有没有内容？240 条之前还有没有内容？原貌是个什么样的？我们现在已经就不得而知了。

这一类的条文，如果去强解就势必会造成误导，所以这一类的条文还是存疑得好。

大家看：我们通过用《康平本》和《宋本》这么结合着解读，我们会有许多新的收获，有的都是些从来没有的。

大下后、六七日不大便、烦不解、腹满痛者、此有燥屎也、所以然者·本有宿食故也·宜大承气汤、（241）

胡希恕：这一个是“大下后”，大下后，那要是，啊，一般说那就是，啊…不会再不大便了，那么他除非有特殊的情形，啊。“六七日”，他又“不大便”了，而且“烦”始终不解。“腹满痛者”，这是，啊，这是专就腹证上说的。那么大下后腹不应该满再痛了，他要东西都去了。这一个腹满痛是实啊。既满而且也疼，这指着摁着

说的，拿手摁他特别疼，这是…啊，这是里边实，“此有燥屎也”。那么呢，“所以然者”，为什么大下之后而还有燥屎呢？“本有宿食故也”，这是他这个人本来他就有宿食在内，这个人总是不戒于口了，平时他滥吃滥喝，是吧？这是的确是有的，人的这个肠子也特别长，戒口，啊，那里头还窝着燥屎呢，所以他还是不大便。那么这一个虽然大下之，仍然用大承气汤，啊。他的去病务尽，这也有这个情形。那么有燥屎的证候很多了，头前儿绕脐痛，啊，发作有时，这是一种；这一个，啊，大下之后，六七天也还不大便，而且烦还不解，他热，里头还是有热，是吧？那么腹又满，摁之又痛，啊，这是肯定里头还有东西。那么这一个，这绝对与这个人的平时不摄生有关系，就是乱吃吧，有宿食不去。所以他这个燥屎啊，不是一个…啊，是经久的东西了。它与这个大便硬，是又…啊，又相同又不相同。这个燥屎也是硬的，是吧？但是它这个呢，总是蓄积已久的东西，这个用普通的泻药是攻不下去的。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格排版的条文。

解读一下：

“大下后，六七日不大便”，指的是服用了泻下峻剂之后（要不能叫“大下”后呢），不但没有出现下利不止，反而发生了多日不大便的情况。当然，服下了泻下的药品“大下”之后，肯定出现下利，但下利完了以后又出现多日不大便。条文后边的述症里有“烦不解”，可以知道在大下之前，患者就应该有里实热证，所以用泻下剂，“烦不解”说明在“大下”之前就有烦，本来就有里实热证。为什么大下以后，反倒是出现了更严重的里实热证呢？我们应该清楚，“大下”所用的方剂应该是巴豆类温性的泻下峻剂，患者本来是里实热证，属于方不对证。在经方中能称得上“大下”的，应该非大承气汤莫属了。如果这儿的“大下”是指的服大承气汤，一般不会再次出现结实的情况，即便再出现结实，也没有道理再服大承气汤。但后面方剂里

说得很明白，要用大承气汤来治。

“烦不解”。它是指的“大下”以后仍然有烦躁的症状，这说明大下所用的方剂必是温性方剂。

“腹满痛”，是由于大下以后所用的方不对证，而致里热不除，经过了六七日不大便，又发生消化道之内积滞的情况，患者不单单感觉到腹胀满，同时还有腹痛的感觉，这个腹痛在临床中肯定是拒按的，会疼得更厉害。

“此有燥屎也”，这是对里实证所作的病理解释。这个条文论述的是因为方不对证，大下以后又出现了多日不大便，同时烦热不除，并且出现了腹满痛的情况。虽然说经过了大下，但是这个病在病理上仍然属于里实热证，所以称作是有“燥屎”。

旁注“所以然者，本有宿食故也”。本意是指大下之前就有里实证存在，本来想说明这个意思。放到条文里不能算错，但是它有一定的片面性，没有里实证的里热证前边学过，对于没有里实证的单纯的里热证，误下以后也有形成里实证的可能。比如第 238 条论述的就是这类情况。这个旁注认为如果没有宿食的话，大下以后就不会发生大承气汤证这类，有这个意思。而条文所论述的，大下之后出现里实热证的关键是开始用“大下”，方与证不相应，不是讨论前边有没有宿食的问题，所以说注解有时候是经不起推敲的，旁注有相当一部分经不起推敲。

病人小便不利、大便乍硬乍易^①、时有微热、喘冒不能卧者、有燥屎也、宜大承气汤、（242）

注：“大便乍硬乍易”《宋本》作“大便乍难乍易”。

胡希恕：所以这个地方啊，都非常的好，在这个燥屎各种证候，他给你，啊，列到这个地方，不是一个证候。病人小便不利，这个小

便不利呀，它水谷不别呀，它要走大肠的，是吧？一般来说都应该下利，啊，起码大便溏啊，溏就是溏泻了。而反“乍难乍易”，乍难乍易就是一阵难，一阵容易，但是它不是稀的，啊，这个“难”者就是“燥屎”，这就是有燥屎的一个情形。他由于这个水在肠子里头，而反到乍难乍易，这是有燥屎一个明证啊。那么底下，看看它这个证候。虽然“时有微热”，微热还不是经常的，有的时候有，有的时候他也没有，那么可见这个热结于里，而不现于外，现于外也是隐隐的，啊。但是“喘冒不能卧者”，这个喘、冒都是个实象啊，这个热虽然现外很微，但是上攻相当凶猛。这个冒是昏冒啊，啊；这个热它往上攻，所以他这个外边它才不显。它一方面结于里而往上攻，所以这个也不可轻视，大承气汤主之。这个“喘”，这一个不是在表那个喘了，这个他往…这个热外上壅逆，啊，压迫这个横膈膜这个喘。这个昏冒也是热，攻冲头脑而造成的。这个地方没有旁的，就得记呀。所以这个临床上用大承气汤，这个大承气汤是个厉害药啊，啊，真正重病非它不能行，可是轻的用它就坏事。所以用这个药又要慎重，又要辨证辨的清楚。那么他这几段都是啊，那么有什么情形之下来用呢，就是上边说这个全是。

李冠杰：这个条文在《康平本》是一个降一字格排版的条文。

“大便乍硬乍易”，在《宋本》里边被改作了“大便乍难乍易”，这样好像是逻辑上更通顺一些。

“病人小便不利，大便乍硬乍易”，虽然论述的是二便的症状，但是这两者之间存在着一定的关联性。“小便不利”是指的有停饮了，但是大便却呈现出一种特殊的情况，“乍硬乍易”就是有时候解的又硬又难，有的时候解起来还比较容易。这是由两方面的因素造成的：一方面他有严重的里实证，另一方面，他又有比较明显的停饮证，停饮的因素存在，中医里边叫“水走肠间”。如果人体有里实证，又有“水走肠间”这一方面的倾向，那么他就易出现所谓的“热结旁流”，

这儿说的“易”，实际上与正常的大便不是一个概念，而是大承气汤有痢疾的情况。因为硬便还能下，不是老在泻一些清水之类的，这个地方我们可以把它认为是：大承气汤证里边的那些痢疾疾病之类的一些轻症，还到不了那个程度。

“时有微热，喘冒不能卧者”，如果上边论述的这种情况，再出现此类的症状，就说明里实证已经非常严重了。“时有微热”，尽管它是微热，它也是里实证的症状反应，但是为什么没有表现为潮热呢？就是因为有停饮证的存在。所以说人体不容易出现那种潮热、高热的那种体温。“喘冒不能卧”，这主要就是里实证，当然也有停饮证这两方面的因素造成的。患者不单单因为腹腔内宿食与水饮积滞而造成喘满短气，而且严重到了，如果平卧，这些症状还会明显加重的程度。这也证明一个问题，“喘满”是因为腹腔里边有积滞造成的，人平躺以后，上迫横膈膜的力度会更大。同时患者还因为这种因素出现了晕冒的这种情况，可见这个病情是比较严重的。

上边这种情况，虽然说没有大承气汤证这一类方剂的典型的症状反应，甚至于小承气汤和调胃承气汤的典型的症状反应都不十分具备，但是不等于里实证不严重。所以说这也要界定为“有燥屎”，治疗就“宜大承气汤”。当然这给的有斟酌的余地，但这个地方它想说的是，这种情况就是一个急症、重症，因为里实证已经闹得他“喘满晕冒”了，是比较急迫的。

食谷欲呕者^①、属阳明也、吴茱萸汤主之、（注）得汤反剧者 属

上焦也 • ②（243）

注：

1. 《宋本》无“者”字。
2. 《宋本》此处有“吴茱萸汤”四字。其后有吴茱萸汤方及方后注，此从略。

胡希恕：“属阳明也”，这一个是个错误，叫我看，应该“属胃”。这个不是属阳明病的。阳明病我们头前儿讲那个，啊，开始他那个提纲，阳明之为病，胃家实也，啊。就是太阳阳明与少阳阳明也都是…啊，所以脾约也好，啊，啊…烦躁大便难也好，全与这个吴茱萸汤这是毫无关系的。这个他是虚寒呐，胃虚有寒，所以食而不纳，他呕。这是胃…胃虚有寒，这不是阳明病啊，是吧？那么“得汤反剧者”，它不是胃虚有寒了，“属上焦也”，属上焦指着小柴胡汤说的，上焦不通嘛，啊，他是热结于胁下这个地方儿。这一段书不应列到这儿。他这一段主要的是吴茱萸汤与小柴胡汤，对于治呕的一个鉴别点。一个是虚寒，一个的确是热有饮，啊。这两个看似相同实质是不同的。那么小柴胡汤呢，啊，他有小柴胡汤证啊，那也很好辨别。但是就这一点上是相同的。小柴胡汤是心烦喜呕啊，是吧？那么这个吴茱萸汤也有时候烦躁啊、呕吐，他烦躁、呕吐，是胃折腾的，他是闹得厉害，那个是躁多而烦少。那么这一段，虽然我这么讲，啊，但是不应该列到这儿，大概它应该列到这个太阴病里，这就对了。他虚寒嘛，胃虚，有寒饮，食谷欲呕。这个吴茱萸汤也不光治食谷欲呕啊，这有很多，后头我们还要讲的。那么这一个方子应用的机会很多。他胃虚有寒饮，冲逆头脑，头疼啊、头晕呐，所以我们在临床上遭遇很多呀，这一个，这一个方子啊，啊。有很多美尼尔氏症，啊，头一晕腾，就要吐，吐得挺凶，那吃吴茱萸汤就好。这一个你们在临床上可以试验。再不偏头疼，尤其是右边儿偏头疼，大概都是用吴茱萸汤证。很多，啊，同时它也治胃疼。胃疼也得属于虚寒，有寒饮的这种情况。治头疼啊，头晕呐，只是呕吐、恶心。但是他不是阳明病，他怎么是阳明病呢？所以他搁到这儿，又搁个属阳明仁字，这都王叔和干的。王叔和他这是…他记这个书的时候啊，他一看，遇着阳明就往里头搁，啊。究其实这个“属阳明也”也说的“属阳明胃”，啊。所以我们顶好就把它改个“属胃也”啊，比什么都强。有很多，后边还有，啊。

李冠杰：这个条文在《康平本》是顶格的条文。

这个条文“食谷欲呕者”的“者”字，在《宋本》里边没有，去掉了。《宋本》在这个条文的最后，有“吴茱萸汤”四个字；另外，还附有吴茱萸汤及这个方剂的方后注解，《康平本》里边没有。

“食谷欲呕者”，就是吃食物以后，出现想吐的这种症状。从临床统计资料来看，这个“呕吐”，确实实是吴茱萸汤的一个主证。但是在经方理论当中，或者在经方的方证当中，有这一类症状的方证还有很多。比如：大黄甘草汤、小半夏汤这一类的，都是比较明显地吃东西就想吐。如何鉴别呢？这就涉及到要准确地把握吴茱萸汤证呕吐的特点，因为这个条文就说了一个“呕吐”。如果想把它理解得比较准确，我们不仅仅是要参照其他相关的一些条文，同时还要结合方剂，来深入地理解吴茱萸汤证的“呕吐”。

从这个方剂的药物组成和相关条文的论述方面分析，这个方证的“呕吐”，属于典型的“里虚寒证”。是由于虚寒证而造成胃肠的功能低下，才出现这种“呕吐”的症状。所以它与那些里实热证或者单纯的停饮证，在病理上有质的区别。这个方证在“呕吐”的同时，还会表现出一系列的里虚寒证的病理特征，因为它的病理就是这么一个基础。

比如，脉实、脉沉、脉弱，舌淡、苔白，四肢不温，不喜饮食，不仅仅是不喜饮食的问题，一想吃东西就感觉难受，不吃都难受，甚至有时候还会出现下利。

另外呢，吴茱萸汤证还有一个特征性的症状反应，就是头疼和头晕。这在临床当中，可以作为吴茱萸汤与理中汤之类方剂的一个主要的鉴别点。

下面是“属阳明也”，这句话出现在这儿，是一个不折不扣的错误。虽然这个方证从疾病类型上属于里证，这个没问题，但是它是一种典型的里虚寒证，与阳明病的里热证、里实证，属于相反的疾病性

质。而且在临床表现方面，它和阳明病的里热证的症状反应共同点也比较少。所以这一句出现在这个条文当中，其中必然有错误。一个是错误本身非常明显；再一个呢，这个错误非常低级，里边没有可以变通的余地。因为无论怎么解释，说吴茱萸汤是阳明病，那都解释不通的。

特别它还是一个顶格排版的条文，它绝对不是原作者的原样，不是原作者的本来意思，其中肯定另有原因。原因何在呢？我们现在也无从考据。

这个条文的后边有个附注，“得汤反剧者，属上焦也”。这个附注在《宋本》窜入了正文，所以一直以来，都被历代注家当做正文来读。今天借助于《康平本》，回归成原来的样子，把它当作注解内容来解读的时候，理解上就会有所不同。

这个注解，是注解的作者本人，在辨证不够准确的情况下，误用了吴茱萸汤的经验。这个患者本来不是吴茱萸汤证，他误辨为吴茱萸汤证，方不对证。实际上就是误用了吴茱萸汤，用错了，要对症了的话，怎么可能“得汤反剧”呢？那么用错了以后，患者吐得更厉害了。

吴茱萸汤证的病理：里虚寒证合并停饮证。

这个停饮证，我们在学习条文过程中没有仔细地讲，停饮证主要的原因：就是里虚寒，胃肠功能虚弱不单单对食物吸收不好，对水分的吸收也不好。

做个小结：食谷欲吐的，为吴茱萸汤主治之证。

这个方剂在临床应用上，没有小柴胡剂应用的机会多。但是，两个多小时前，我还给一个病人用过这个方剂。给他用的是什么呢？小柴胡汤二分之一，吴茱萸汤二分之一，就是各半。这个病人不管是脉象也好，还是主诉也好，都有明显的里虚寒证，而且他有时候感觉头疼，另外他有柴胡证，所以我给他这个方剂。关于这个方剂的应用，我在临床上单独用它的机会，有那么几次，不是很多。

其中有一次，有个病人就是吐得哗哗的，头晕得下不了床，前后总共吃了六个吴茱萸胶囊。我让他频服，一会吃一个，一会吃一个，让他一下吃进去，说不定他马上就要吐出来，一口水送一个，到了第二天跟我说好了，一共吃了六个胶囊就好了。

另外还有一次，一个病人，他前边有猪苓汤证，自己吃猪苓汤，病已经好了，他觉得吃了以后挺舒服，多吃一点吧。后来就出现反胃想吐，然后头疼得很厉害。因为他吃的猪苓汤就是在我这儿拿的，我就知道他偏寒了，就给他拿了吴茱萸汤，吃了一次，就头不疼了，胃里边也舒服了。

这个方剂有四味药物组成：吴茱萸、人参、生姜、大枣。那么人参、生姜和大枣，这三个药物合在一块，可以健胃补虚，有增强胃肠功能的作用；在这个方剂当中还有一个很重要的作用，在改善胃肠功能的同时，尤其改善胃对水分的吸收功能。特别是这个生姜，对生姜的解释常常会说到它有行水的作用，实际上它的行水，就是能改善胃的功能，胃吸收水分吸收得好，但是它没有利尿的功能。吴茱萸在这个方剂当中是主要的药物，这个药，是一味热性的，比温性还要热一些，有降逆止呕、温中散寒和杀虫止疼的作用。从吴茱萸所对应的病理来看，和干姜比较相似，但是这个药比干姜还要偏热一些、热性比干姜还要烈一些，而且有一定的毒性。在经方当中，含有这个药物的方剂总共有四首。《伤寒论》里边有吴茱萸汤和当归四逆加吴茱萸生姜汤，《金匱要略》里边有九痛丸和温经汤，就这么四首方子。这四首方子都是治疗里虚寒证的，从这儿可以看出这个药性不仅仅是偏温的，而且比较热。

吴茱萸汤证主要的症状：呕吐、头疼、四肢不温、面色不华、、烦躁、下利。这儿虽然是临床统计资料不错，但这儿有一个问题，就是吴茱萸汤证不仅仅是头疼，还有头晕。这个头痛有巅顶痛，有顽固性头痛，有偏头痛，但是没有头晕。事实上临床当中，这个头晕还是

出现频率很高的，美尼尔综合征，常常表现为吴茱萸汤证。曾经我的一个学生，他孩子感冒了，感冒了以后，输液不好，他就告诉我：孩子就是头晕、不能吃东西、然后有感冒症状。我就跟他说：用小柴胡汤合上吴茱萸汤，后来他又合了点理中汤，那孩子吃下去就好了。

舌质：淡舌、淡红舌。

舌苔：白润、白腻、白滑、薄白。

脉象：迟脉、沉弱脉、沉缓脉、沉弦脉。

在吴茱萸汤证这种病理状态下，容易出现的现代疾病：青光眼、高血压、胃炎、胃及十二指肠溃疡、神经性呕吐、贲门痉挛、慢性非特异性结肠炎、慢性肝炎、神经性头痛、胃肠神经官能症、癫痫、冠心病、痛经、带下、肌肉痉挛、妊娠恶阻、美尼尔氏综合征。

大阳病、脉缓浮弱、寸关尺·其人发热汗出、复恶寒、不呕、但心下痞者、此以医下之也、如其不下者、病人不恶寒而渴、渴者此转属阳明也·小便数者、大便必硬、不更衣十日、无所苦也、渴欲饮水、少少与之、但以法救之、渴者、宜五苓散、（244）

注：《宋本》此条文如下：

太阳病，寸缓关浮尺弱，其人发热汗出，复恶寒，不呕，但心下痞者，此以医下之也。如其不下者，病人不恶寒而渴者，此转属阳明也。小便数者，大便必硬，不更衣十日，无所苦也。渴欲饮水，少少与之，但以法救之。渴者，宜五苓散。

（另，《宋本》此处有五苓散方及方后注，此从略。）

胡希恕：这是共计有这么三段，这一条儿里头。他本来是“太阳病，寸缓关浮尺弱”，寸缓者就是津液不足于外，啊，脉浮缓嘛。这古人有“寸缓则为中风”，就是太阳中风，那么尺缓，就尺弱也是一

样啊，啊，“则为亡血”就是血液少。那么在仲景头前儿咱们也有嘛，“营气不足，血少故也”，所以脉迟，啊。那么“关浮”，这一个脉呀，总而言之就是个脉浮缓，啊，脉浮缓弱这么一个脉，这是太阳中风的脉。他为什么要这么分呢？他也有用意的。这个关以候胃，就是心下部位。这个浮呢？在这儿主热，他也主…也主外也主热，也主表也主热。这个关浮者，就是心下这个地方“痞”，这个痞是热痞了，啊，他用泻心汤治疗的，他是指的这个说的。所以他把这脉呀，啊，他用这个部位来说明这个病的……啊，情况。那么我们要看这个缓和这个弱这个脉不好分的，这个“缓”呐，指着这个脉松弛，这个脉道松弛，啊。你看我这个烟卷，这么拿着它紧，它裹的紧嘛。如果你把这个烟倒出去一半，你再摸这个烟卷觉缓，啊，松弛，没力，它，它…冲着圆度上说的，啊，它是有紧有缓。那么这个弱呢？弱的呀，它从这个弦上说的。脉弦，弦就是上下崩直啊，啊，就弓弦那个弦，咱们弹…弹弦那个弦，你要新把它…啊，新张之弦，你摸着上下溜直。日久你也不上弦了，这个弦就松弛了。所以这个弱呀，它是冲它上下看这个弱，不禁摠。这…理上讲是有，咱们指象上来分别呀，很难，这个缓和弱分别很难。所以张仲景这个书，他缓弱是通用的。他说太阳中风，啊，发热，汗出，恶风，脉缓。他讲那个太阳中风治疗的时候啊，他又说阳浮而阴弱，哎，他又讲个弱。可见这缓和弱呀在我们这手象上来分别很难。在这个理论上来说来有的，存在，啊。那么这一个脉呢，总而言之太阳中风的脉，脉浮而缓弱。“其人发热汗出，复恶寒”，就是太阳中风的症，太阳中风发热汗出，啊，还恶寒嘛，恶风恶寒。那么“不呕”，说没传到半表半里，那就没有柴胡证啊。“但心下痞者”，他也没传…啊，少阳，那么他胁下不结，没有胸胁苦满，可“但心下痞”，心下这地方呀，他有痞塞不通。那么这是怎…一看这一个病的情况，表还没解，而有心下痞，这就是，大概是“以医下之”作的，啊，毛病。下之表没解，那么外邪内陷，所以心下痞，

大概是这么个情况。这头一段就是说的这一个。但是，他没出治疗的法子，这头前儿都有啊。那么我们应该先用桂枝汤以解外，然后以泻心汤再以治痞，或者大黄黄连泻心汤，或者三黄泻心汤，我净用三黄泻心汤的机会多，这是一段。“如其不下者，病人不恶寒而渴者，此转属阳明也”，如其不下，这个病人呐，已经不恶寒了，上头他说是发热汗出，复恶寒嘛。不恶寒只是心下痞而又渴，那这是转属阳明了，渴了，内里头一热他就渴。那么这个痞呢？这是，啊，不过问题不大，他不是大实大满，只是这痞，啊，稍有点内实的样子，不大。所以他是转属阳明，他这个转属阳明啊，就是太阳转属于阳明，太阳病没拉倒呢。转属就是并病的一个互词，啊，他说转属都是个并病啊，但是太阳病要罢了，他已经不恶寒了嘛，又渴，啊。阳明病已显了。“小便数者”，这时候的小便呐，频数的厉害，那么大便它要硬，但是大便硬也不谵语，也不捂的，他内里头热并不太厉害，啊。“不更衣十日，无所苦也”。这就我们头前所说的这一个，这是津液内竭，造成大便硬，只是由于小便数，虽然十日不大便，毫无所苦啊。这个言外呢？不可攻。我们只是用当与大便的法子也可以。那么后边呢？根据治脾约吃这个麻子仁这一种也可以，看你病的轻重了。如果重，多少有点热，可以吃麻子仁，啊，麻子仁丸，就是现在说，麻仁滋脾了；不然的话，他就是用那个导之之法，啊，像我们头前儿蜜煎导啊，猪胆汁，啊，那种法子。那么假若他要是渴，啊，而欲饮水，那可以少少与饮之，啊，但以法救之。少少与饮之，不要给喝的多，喝的多非喘不可。这一个…他这没有多大的热，一点一点给。给点水呀，他由于小便数丧失津液，胃和者愈嘛。“渴者”，这后头又有一个“渴”，这一个“渴”字啊，他是承上边这两段说啊。那么头一段“下之”，下之后表还有热没解，心下痞。这一个心下痞呀，有由停水的关系，五苓散证有的，啊。他由于下，气上冲，它造成小便不利，这一个绝不是小便频数啊。小便不利微热而渴，那五苓散证，这个“心下痞”

正是水气，它是逆于心下。所以他为什么不详说呢？这是个简文。他搁个“渴者”这两字就代表了，头前儿都有。这是啊，啊，承接第一段。第二段也是一样的。他说要是“不下”也可以发生这一个证候。那么病人，啊，微热不恶寒而渴，这一个也没转阳明，可没有底下这一套，啊，他没转阳明，但是他是小便不利。这一种渴，这也是停水不行的，啊，也可以用五苓散。他就这渴上发挥的。不是说转属阳明小便数，你还给吃五苓散，这个不对了，啊。我们头前儿讲那个猪苓汤都有啊，是不是？他已经丧失津液了，你不能够一直丧失津液，到这么个分气上，你不能再吃五苓散。我们头前儿讲过，啊…这个附子汤，是吧？治这个风湿相搏。他有那么一个，啊，小便利，啊，大便秘者，去桂加术，那一个加术，他治小便利，他不是让他利小便。这个术与附子为伍啊，这我当时也讲过，是吧？你像那个真武汤啊，啊，你像这个术附为伍，他说这个，这个机能啊，这个泌尿这个机能松弛，啊，不能收摄，那么使那个机能恢复，而再加上这个…啊，水的药，它反到治小便不利…啊，小便利。所以附子配伍那个药。五苓散不行，啊，这个五苓散这是利尿相当有力量，而且他是个阳明病，啊，真要是内传阳明，这桂枝它不治里热呀，所以这一个大家很有争论。我认为这个“渴者”是另起的；不是接着上边，不是说少少与饮之，而还渴不止，这一个不是的，啊，这一个不是。他已经大便硬了，你不要再利水了，复利其小便那是不行的，猪苓汤都不能用，那五苓散更不能。那么这是个简文，他为什么不详细说呢，因为这头前儿都说了，啊。你们回头看看那个五苓散，头前儿说那些结论就知道了。所以他这个书啊，在阳明病篇这些东西不尽是属于阳明病，你看这一段与阳明病什么关系啊？它比较不让你这么用。

李冠杰：这条很值得推敲，在《宋本》里因为把旁注内容窜入正文，对原文的改动比较大。《宋本》的条文是：“太阳病，寸缓关浮尺弱，其人发热汗出，复恶寒，不呕，但心下痞者，此以医下之也；

如其不下者，病人不恶寒而渴者，此转属阳明也，小便数者，大便必硬，不更衣十日无所苦也，渴欲饮水，少少与之，但以法救之；渴者，宜五苓散”。

《宋本》里这条最后附有五苓散的方剂和方后注，《康平本》没有。

解读一下：

“太阳病，脉缓浮弱，其人发热汗出，复恶寒，不呕”。这一段文字论述的是典型的太阳表虚证。“脉缓浮弱”中的“浮缓”脉说明仍然是表虚证的脉象，“弱”脉是表虚证经过误下以后造成的。尽管还是以前的表证，没有发生质的变化，却在症状和脉象上都有一些新的变化，但是疾病的本质并没有变。这儿的脉象，实际上是别的医生误用了下法之后，这个作者又见到的脉象。理论上说，作者是见不到误下之前患者的脉象。这种论述实际上都是从临床中抽象出来的，这个地方关键的问题还是要说明：误下以后，人的病还是表虚证，症状也大都是表虚证的症状。但这个时候脉象比表虚证的脉象还要弱一些，这是正常的。实际临床中的脉不一定真正就有这么微小的变化，不一定都能从脉上反映出来，但说的就这么个意思。

再看看症状：“其人发热汗出，复恶寒”，都是标准的太阳表虚证的症状。但是症状也有一点小小的微妙的变化：“复恶寒”。实际下了以后，恶寒比以前重了一些，但还没有到引起疾病发生质的变化的程度。“不呕”的意思，就是没有因为误下而发生少阳病，仍然保持在太阳表虚证的阶段。

旁注：“寸关尺”。在《宋本》里把它窜入到正文，还与正文混在一起，改成了“寸缓关浮尺弱”。这给正确理解原文造成了极大的误导。我们在这儿不去论对与不对，以及能否与临床接轨的问题，因为那个范围很宽。但这种对原文的改动方式是极不严肃的，不管是哪一个历史阶段，对于原著进行这样的改动，都不如自己再写一条。这

种方式最轻的也是严重歪曲了“寸关尺”那个作者的本意，没有必要这要改，个人的理解可以参照《康平本》的样子在一边加注解。

“但心下痞者，此以医下之也”。这一句是正确理解条文的一个关键点。“但心下痞”说的挺有味道，前边有“发热汗出复恶寒”一大堆症状，为什么又说“但心下痞”呀？实际上就是说，在表虚证的基础上就出现了“心下痞”的不适感。言外之意，没有其它的阳明病或里虚寒证之类的，就只是一个“心下痞”。意思就是说，这个心下痞不是疾病发生了变化，虽然经过误下了，但病本身没有发生质的变化，而是病人吃了泻药以后，因为胃受到刺激造成胃不舒服的感觉，不要认为发生了里证。所以后面紧跟了一句“此以医下之也”。从这一点看，前面的脉弱也是这个原因造成的。要这么去读这段条文的话，文字非常严谨，写得非常细腻。

下面是另外一个问题：“如其不下者，病人不恶寒而渴，小便数者，大便必硬，不更衣十日，无所苦”。论述的是下之前的一种情况，这地方说得很清楚：“如其不下者”嘛！这里面就有问题了？

没经过他医来用泻下药治，里面的那些症状跟这儿还有些关系，比如说脉象，作者是想用脉象来表达对疾病本身的一些理解，实际临床中不一定准现“缓浮弱”这种脉象。缓浮近似于表虚证，弱脉跟这还是有关系的，缓浮到这个地方就不是表虚证的问题了，因为这有“不恶寒”，疾病性质是另外一种疾病了。刚才说的那个是表虚证，下了之后它还是表虚证，但同时表现为脉弱和心下痞；这儿说的是病人没有经过下也脉弱，也可能有心下不舒服的感觉，也可能有时候会有点热，或者有汗出，这都有可能的，但出现的几率肯定是不一样的。它跟真正的表虚证是不一样的，虽然有某些相似的地方，但是病人“不恶寒”了，那就不一样了。还有“小便数”，这是表证里面不应该有的，如果有的话，表证就等于和其它类型的疾病合病了。还有“大便硬”，而且十来天不解大便，也没什么痛苦。这一段说的是这样的一

种情况。这儿的论述的就是一种：既有里热，同时又有津液虚，又有里虚证的一种情况。一会儿还要跟大家说说这个里虚证是怎么回事。也就是说患者没有造成承气汤证类方证的消化道内极端亢奋的那种机制，所以说“脉弱”跟这儿就会有一定的关系。

这个“十多日不大便”，虽然是跟热有关系，再加上津液虚，造成消化道内水分过少，再加上胃肠功能偏于低下，才使肠道内容物长期的滞留在消化道以内，多日不大便而“无所苦”就是一个典型的证候！如果有那种消化道机能偏于亢奋，出现承气汤证的话，就会痛苦的不得了。这儿没有那种情况，说的是阳明病中人虚病实的一种特殊情况，如果从病理、症状反应角度来做全面的权衡分析，你会发现这实际上是第 247 条中的麻子仁丸证。

再往后的条文内容就有点问题啦，简单一读就会发现不通顺、重复。但是只能按照这个先解读，然后再回过头来客观地再分析它。“渴欲饮水，少少与之，但以法救之”，指的是条文上边论述的两种情况：

第一种是太阳表虚证误下以后仍然是太阳表虚证，但是出现了心下痞的症状，如果同时存在渴欲饮水的症状，是因为误下导致短时间内人体津液虚了，出现了口渴的情况，这种情况少少给些水喝，慢慢地恢复津液，过一段时间就会好的。这个早就在太阳篇里就有论述。等津液恢复了以后怎么办呢？这儿交代得也很清楚“以法救之”，就是该吃什么药吃什么药，比如该服桂枝汤还服桂枝汤。

第二种情况是没有误下，就是说它既不是太阳病，又不同于阳明病中承气汤证那类的里实热证。如果在那种情况下出现的渴欲饮水，也要少少给他水，因为渴嘛，但饮得多了，会因为暴饮而出现其它变证，为避免这类的情况，让他稍稍缓解一些口渴，补充一点津液，然后也还是要以法救之。“以法救之”怎么治呀？麻子仁丸呢！

论述的这种情况无论是从病理上，还是从症状上，跟临床统计资料也能对得上，是比较吻合的。为什么会这样？下边会一点一点咱们

再看，它这个应该出的什么样的问题，这是我们今天试着要解决的问题。

后边“渴者，宜五苓散”。这个“渴者”显然跟前边“渴欲饮水”就重复，前边说了“渴欲饮水，少少与之，以法救之”，后来又一个“渴者”，显然这地方很可能有错简。但是从条文论述的第一种情况来看，也就是说太阳病误下以后，如果表证仍在，又有一点心下痞的症状，同时再有“渴欲饮水”的“渴”这种症状，确实有用五苓散的机会。咱们学习知道五苓散能治停饮——像那个得有小便不利，把五苓散方剂搁到这儿了也可以，如果你对经方理论熟了的话，就会观察是不是因为小便的问题，有没有停饮的问题，如果有的话，也有应用五苓散的机会。但是后边一种情况是里热和津虚为主的，应用五苓散的机会相对地就偏少了。

再回过头看看条文里的旁注：“渴者是转属阳明也”，它是指条文里论述的第二种情况，出现了“不恶寒而渴”的这种，是由太阳病发展而来的，因为“转属阳明”嘛。但实际上条文论述的第二种情况多数是慢性病，单从“不更衣十日，无所苦”就能看出来这绝不是急性病，是慢性病。所以，这个病并不一定要经过太阳病的病理再发展过来，而且在实际临床中，像麻子仁丸证这类的病人大多数都是长期的习惯性便秘患者，一般都没有经过太阳病的前期阶段，所以这种论述本身就可有可无。但是《宋本》把注解内容窜到正文里，对后世的学习也产生了一些误导，特别是条文论述的，就是没有经过“下”的情况，因为它将“渴者此转属阳明”窜到正文里面去了，差不多所有的读者都理解成这是太阳病转属阳明病了。但是如果把注解从原文中去掉，很明显可以看出来原文论述的实际上是没“下”以前的，不是太阳病下了以后转属阳明病的，是不经过误下的那种。原本一开始就是跟第一种那个下之有区别的，因为那有恶寒，它说的是另一种不恶寒的，所以说不是从第一种情况演变过来的。

这儿，就在强调这是一种阳明病里比较特殊的情况。特殊在确实有热，也有里实证，还有津液虚，但是还存在着人虚。所以才出现这么特殊的症状表现：十多天不解大便，也没什么痛苦。实际在临床中还有时间更长的，我听说过的有将近一个月不解大便的，让人感觉不可思议。不用说一个月，如果十来天不大便，吃的东西哪去了？一天吃半斤还得五六斤吧。不仅仅不感觉痛苦，而且从外面看有的患者还挺瘦的，挺苗条，都让人觉得不可思议。

最后再看看条文后边，因为涉及五苓散的问题，而且条文后边明显的有文字、内容上衔接不是很顺畅。还有，从这条一直到第 247 条的麻子仁丸证方，这几条都是降两字格排版的文字。如果从这个角度再去看看附近的条文，无论《宋本》还是《康平本》，慢慢去品一品，会感觉附近的条文都有一些问题的。以及前面刚学的吴茱萸汤证，明显得就是个错误，之后的条文有一些也是有问题的。这不是一个偶然的问题，我给大家做一种推想：很可能是王叔和当时搜集到的这本书，这个地方本身就有严重的散乱，或者残缺，有可能竹简都散了，后来勉强把它凑起来，缺什么东西，能补的就补补，有可能就属于这种情况。

这个条文第一种情况，是非常简单的，治疗也没有问题，而且条文里也没有交代，不交代也不会有多大影响，因为在其它条文里论述得很清楚。第二种情况，如果把它跟第 247 条麻子仁丸证结合在一块，也是非常清楚的，就是一个麻子仁丸证。它论述的就是阳明病里一种比较特殊的情况，而且麻子仁丸是以小承气汤为基础，又加了有补中益气作用的一些药物，加了麻子仁、芍药、杏仁嘛，所以从病理上也和这一条非常吻合。咱们学到麻子仁丸的时候，还会对那个方剂做进一步地探讨。

脉阳微而汗出少者、为自和也、汗出多者、为大过、阳脉实、因发其汗、汗出多者^①、亦为大过、大过者、为阳绝于里、亡津液、大便因硬也、（245）

注：“汗出多者”《宋本》作“出多者”。

胡希恕：（音频缺如）

脉象浮沉相对，浮为太过，属阳，沉为不足，属阴。阳脉微，指脉浮而按之微，即太阳中风的脉浮弱（浮缓）。阳脉实，指脉浮按之而不微，即太阳伤寒的脉浮紧。

太阳中风则自汗出，若汗出少者，津液无大损伤，故谓为自和。若汗出多，致津液大量丧失，故谓之太过。太阳伤寒当发汗，但发汗取微似汗，若大发其汗而使汗出多者，亦为太过。无论自汗与发汗，汗出太过则津液亡失，必使阳绝于里，大便因而硬也。

【按】太阳中风自汗出，津液虚于表，故阳脉微；太阳伤寒无汗，津液充于表，故阳脉实。仲景于此不言脉浮缓、脉浮紧，而言阳微、阳实者，正是教人明白所谓阳绝于里者为津液绝于里也。书中所论亡阳亦多指亡津液，一些注家执定阳即热，甚为不当。

【注】

①阳，和阳脉实中的阳字，均指浮脉。微是细而虚（无力）的兼象。脉阳微即浮而微，乃太阳中风的浮弱脉。阳脉实者，即太阳伤寒的浮紧脉。

②汗出太过，则大量亡失津液。

③阳，指津液，参考 27 条注可知。绝，不能机械的理解为竭绝，当是津液亡失太过的意思。

【按】在脉学上，太过为阳，不及者微阴。仲景著作中，脉的阴阳在部位、取法、机能、物质上各有所指，并无玄虚之弊。兹举本书为例：第六条，风温为病，脉阴阳俱浮，其阴阳指尺部与寸部。第十二条，太阳中风，阳浮而阴弱，其阴阳指脉的内外，既有机能上的又

有物质上的。本条脉阳微、阳实是指浮脉而言。所以读仲景书要琢磨文义的真正涵义，是要下苦功夫的。本条屎硬不该以大承气汤攻之，自不待言。

李冠杰：这是一个降两字格排版的条文。

“汗出多者”，在《宋本》是“出多者”，去了一个“汗”字。下边来简单地解读一下：

“脉阳微”，是指浮取有微弱缓和之象的这种脉象，在这儿应该是指太阳表虚证这一类的病而言。

“脉阳微而汗出少者，为自和也”，这就是说，太阳表虚证的常态下，像桂枝汤证，它表现为脉浮缓，发热汗出，但是它的汗出的量不多，不会因为津液丧失很多而伤及人体，这称之为“为自和也”，就是说这是表虚证常态，并不是说没有病。

“汗出多者，为太过”，这是指的阳明里热证而言。如果是在桂枝汤证的基础上出现汗出多的话，那就有可能是桂枝加附子汤证了。桂枝加附子汤证的话，它既不能属于太过，也不一定会出现大便硬啊。所以说这个“汗出多者”应该是指热证而言，是另一个问题了。

“阳脉实”，就是指的浮取充实有力的这种脉象，在这儿应该是指的太阳表实证而言。应该用麻黄剂这一类的方剂来发汗，这儿也说得很清楚，“因发其汗”。但是通常情况下，发汗应该是让他微似有汗为度，如果出大汗，就属于不当的治疗了。如果属于这类情况，也属于太过，就是“亦为太过”，就必然会伤及人体的津液。

“太过者，为阳绝于里，亡津液，大便因硬也”。就是说，凡是上述的情况，都会造成人体津液的损失，除了那个“自和”之外。结果就有可能出现大便硬的症状。“阳绝于里”的“阳”，是指津液而言，包括许多降两字格条文里边，不只是这一处指的是津液，还有其它地方。

这个条文论述的实际上就是人体津液虚损，损失过多，是造成大

便硬的一个重要的因素之一，就这么个意思。你看它文字写的不少，实际上就说了这么个意思。

脉浮而芤，浮为阳，芤为阴，浮芤相搏，胃气生热，其阳则绝。（246）

胡希恕：（音频缺如）

【释】浮为太过，主表主热，芤为不及，主津血不足。脉浮于外，芤于内，为热亢于外而津血不足于内。浮芤相搏，即热与津虚互相影响，必使热者愈热，而虚者愈虚。由津液外越，胃中干而生热，故使阳绝于里。

【按】此论津液自虚，非因他故亡失者，故专以脉论。津虚本可致热，热盛更使津虚，二者相搏，必致胃气生热，阳绝于里，大便硬自在言外。

【注】

①脉浮而芤，即轻取浮大，重按觉血行滞涩而无物。芤脉乃浮大其外，空涩其内之象，故主血虚、虚劳。亦有谓芤为应指两头有、中间无者，实非。

②浮为阳，芤为阴。此处的阴阳系指脉的属性。脉浮于外而芤于内，为阳亢于外，津血不足于内。

③此处的阳字指津液，当有别于本条中前一个阳字，不可不知。

【按】本条暗示，大便硬除阳明热盛里实，销铄津液，汗出伤津，亡血失液以外，还有病人体质津液自虚者，须知。浮为阳者，谓卫气强于外，芤为阴，谓荣气虚于内也。荣卫不和，当自汗出不已，以至胃中干生热，阳绝于里，大便因硬也。可与 53 条注互参。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降两字格排版的条文。

“脉浮而芤”，指的脉轻取即得，就是有浮象，但是，浮大中空，

形似葱管这一类脉象，里边空了。

“浮为阳”，指“浮脉”是有余的脉象。具体到这一条，指的是有里热而言。

“芤为阴”，指“芤脉”是不及的脉象。在这儿，指的津液虚。

“浮芤相搏，胃气生热，其阳则绝”，就是指浮脉与芤脉同时出现，则说明不单是有里热，而且还存在津液虚的情况。后边，“胃气生热，其阳则绝”，也是这么个意思。

“浮而芤”这个脉象，常为里热津虚一类的证候，就是候这一类的证候。虽然在临床当中，并不是这么简单的对应，凡是浮芤脉，全是有里热津虚的情况，不一定。但是这个条文要表达的就是这个意思。凡是这一类以脉定证，以脉定病的理论，都是不可取的。

趺阳脉浮而涩、浮则胃气强、涩则小便数、浮涩相搏、大便则难^①、其脾为约、麻子仁丸主之、（247）

注：“大便则难”《宋本》作“大便则硬”。

麻子仁二升 芍药半斤 枳实半斤炙 大黄一斤去皮 厚朴一尺去皮炙 杏仁一升去皮尖熬^①

注：《宋本》此处有“别作脂”三字。

右六味、蜜和丸如梧桐子大、饮服十丸、日三服、（注）
渐加以知为度·

胡希恕：（音频缺如）

趺阳脉为足背动脉，古人用以候胃。脉浮主热，胃有热则气盛脉浮，故谓浮则胃气强。涩主津血虚，小便数则耗泄津液，故谓涩则小便数。浮涩相搏必使阳绝于里，大便则硬。古人谓脾为胃行其津液，今胃中干，已无津液可运，则脾的功能亦受到约束，故谓其脾为约，

宜麻子仁丸主之。

【按】以上四条均为脾约证，其因虽各有不同，但津液绝于里而大便硬是一致的。津液亡失致大便硬者，即前所述不更衣十日无所苦也，与大承气汤证的热实燥结，潮热、谵语、烦乱者大不一样，故不可以大承气汤猛攻。若就大便难一证取治，最易弄错，以是连续论述，或以证分，或以脉辨，处处示人以辩证之道，并名之为脾约，出麻子仁丸缓下方，以示与大承气汤的证治有别。

【注】

①趺阳，古代三部九候遍诊法的切脉部位之一，位于足背上踝关节前横纹的两筋间，候脾胃。浮主热（胃热），涩是津血不足，此与寸口脉法相同。

②胃热则气强，其脉浮，小便数乃致津不足，其脉涩。

③约，穷也。胃热和小便数相互影响，水分被夺而伤津，所以大便硬。

李冠杰：这条是一个降两字格排版的条文。

条文中“大便则难”在《宋本》是“大便则硬”，也没有质的区别。

解读一下：

“趺阳脉”，也叫“冲阳脉”，是三部九候脉诊的部位之一。这个脉就在脚踝前侧的地方，应该是足背胫动脉搏动的这个地方。现在也有专门搞脉诊的，三部九候说成是桡动脉这个地方的三部九候，把桡动脉分了三个层次：浮、中、沉。实际上，三部九候原本的意思是古代一种对人体遍体的诊法，它把人体的头部、中部、下肢分成这么三段，就是头、身子、下肢，每一段里都取了三处的脉象，合在一块儿就是三三得九嘛，这样就是三部九候。

“其脾为约”，就是所谓的“脾约”证。“脾约”证不是经方理论里的概念，经方里所有的关于“脾约”的论述都是降两字格排版的

条文，再加上经方很少有用这类的论述方式来论述疾病的。大家看看《金匱要略》里，像比如“肺痿”、“肺痛”这类的病，看它也说是肺，但实际上每一条方证条文里论的全是症状。咱们讲《金匱要略》的时候，首先就得说明那个问题，它跟脏腑无关的，经方理论就是跟脏腑无关。跟脏腑无关，不是说脏腑不在人身上了。就说经方辨证辨的是症状，从症状辨病，辨到病理。因为从经方的方与疾病的对应关系来看，它和脏腑发病没有固定的对应关系，所以在经方理论里，不重脏腑。可实际临床中辨证，脏腑有时候有一定的参考作用，它毕竟是人体身上的一些组织器官嘛！

这条的本意是说，“麻子仁丸证”是一种因为里热证合并津液虚证而造成的便秘。具体的症状反应一个是“趺阳脉浮而涩”，再一个是“小便数”、“大便难”。这条把里热混同于“胃气强”，实际上它说的“胃气强”就是指的里热而言，但是，这跟条文里的方证不相符合，跟病理不相符合。学前边的条文里曾经说了。这是一个特殊的阳明病，不仅仅有里热、里实、津虚，而且有人虚的因素，这是一个比较特殊的情况。所以说“胃气强”跟这个方证不相吻合的，临床统计资料不仅找不到任何“胃气强”的证候，反而是有像面色不华、形体消瘦、纳呆、神疲乏力等一系列人虚的症状。

第 244 条论述的第二种情况，跟这条比较的话，它比这条更为贴切。那么，跟麻子仁丸相关的这部分条文再回顾一下。“太阳病，脉缓浮弱，其人发热汗出”，因为它这有不恶寒呢，后面那个“复恶寒”就去掉了。“病人不恶寒而渴、小便数者、大便必硬、不更衣十日、无所苦也”，它就是说的麻子仁丸证。

我们也说过了，从第 244 条的后半部分就出现了文字内容不相衔接的问题，而且第 245 条、246 条和第 247 条都是降两字格排版条文，这都是王叔和加进去的，加之前应该没有这些文字。这个麻子仁丸应该跟那个降一字格条文是接着的，虽然说没有这么机械，但是里边肯

定有此类原因，不然的话它论述的症状跟麻子仁丸的药证不可能这么相吻合。

麻子仁丸证的病理：是里实热证合并津液虚证，同时还有里虚证。虚是人虚，实是病实，可以称作是一种虚实错杂，因为这个方证比较特殊，咱们把病理再进一步细化一下。里实热中，热证不是主要的因素，是个次要因素，主要的还是里实证，造成里实证的原因是因为胃肠功能低下和津液虚两个因素，所以它跟大承气汤证、小承气汤证也是有区别的。这里边有一个人虚的因素，比较特殊了。

下面看看方剂：麻子仁丸由六味药组成，严格地说应该由七味药组成，它有和蜜为丸嘛。有麻子仁、芍药、枳实、大黄、厚朴、杏仁，实际上就是小承气汤加了麻子仁、芍药、杏仁，它做成丸剂，服的量也不是很多，而且要逐渐地加，一直到大便通了为止。这个方子是小承气汤基础上的加味方剂，小承气汤对应的里实热证偏于里实证的这种病理状态，也正是这个方剂的方证基础。

麻子仁，现在到药店里都说火麻仁，它是一味性平，寒热倾向不明显，同时具有润燥、缓下、补中益气作用的药物。经方中除了麻子仁丸之外，还有炙甘草汤也用到了这个药，这两个方子的适应证都有里虚证和津液虚的因素。芍药在这个方剂中的作用，一个是补血虚，另一个是缓下。杏仁有润肠通便的作用，它又可以行水。行胸膈之水以润下，它有这种作用，所以说它有润肠的作用。

这三个药合在一块儿，它既能助小承气汤下行的力量，等于给小承气汤开路，同时又有补虚增液的作用。这样方剂就具备了既有泻下的功能，同时又不伤人，而且还要求把它做成丸剂来服用，药力释放得就比较缓一些，这个丸剂中用的蜜也可以补虚润下。这个方剂就成了一个既有泻下的作用，同时又可以久服而不伤正的方剂。

值得注意的是，厚朴在方剂里用的是一尺。有人解释它就是一平方尺的样子，或许有道理。但是厚朴真要这么计量，就等于不适用了，

没法去量的。至少通过这个，我们可以看出它跟承气汤类的方剂出处不一样，通俗的说，这不是出自一家的方子。出自一家的方子没必要用两个计量单位。诸如这类的差别，《金匱要略》里的方剂还有好多，都能说明这类的问题。比如丸剂的说法，有的如弹丸大，有的说如兔屎大，实际上这两种东西差不多大，为什么用不同的说法、不同的东西作标准呢？就是因为方剂的出处不一样。

麻子仁丸证临床中统计的范畴：

症状上：便秘是出现几率最高的；然后就是脘腹胀满、面色不华、体形消瘦、小便频数、纳呆、心烦、口干咽燥、头晕、短气、咳嗽、失眠、神疲乏力、精神抑郁、自汗出。自汗出虽然出现的几率不高，但是跟条文里论述的第一种情形“发热汗出，脉缓浮弱”都是比较接近的，确实有这类的症状，所以放在一块儿论述是有一定道理的。

舌质：红舌比较多，淡舌占的比数非常少，大概这两种。红舌里还要分红绛舌、尖和边儿红，有一点点细的区别。

舌苔：有黄苔、薄白少津的苔、苔少、苔白腻。从苔少能看出人虚的一面。

脉象：细脉、数脉、弦脉，三种脉象比较集中。

麻子仁丸治疗的现代疾病：贲门痉挛、幽门梗阻、肠粘连术后、术后肠麻痹、肛肠术后并发症、胃嗜食、不完全性肠梗阻、功能性肠梗阻、感冒（像这儿还有感冒，大家再去品品条文）、习惯性便秘、痔疮、肛裂、冠心病、肺心病、高心病、支气管哮喘、肺气肿、糖尿病、老年性精神病、脑血栓形成、胆心综合症、胆石症、噎膈、妊娠便秘、产后便秘、吐血、失眠、慢性咽炎。

这里边像冠心病、肺心病、高心病，跟麻子仁丸有什么关系啊？

我说一个病人，大家可能就好理解了。我楼上有一个艺术公司的老板，一直在吃我的药。他先是心脏放了三个支架，又找到别的中医吃了两年多的药，仍然有血压偏高、胸闷气短等症状。后来他吃我的

药，第二天就感觉轻松很多了，他就一直在吃，血压最近下来了。他说初犯心脏病的时候，曾经在做手术前后有便秘。有一次医生告诉他解大便就在床上，不要下床，而且要悠着劲，不要用太大的力。他觉得人解大便不就是正常的生理功能，何必在床上解呢。结果有一次便秘得很厉害，因为太用力，通身出了大汗，人差一点休克了。从这个事可以看出，凡有心脏病的又有便秘，都要非常小心，大家就能体悟出这儿的冠心病、肺心病、高心病指的是有便秘的那一种。

还有一个问题要注意。这个方剂大家都知道它是治便秘又不伤人，所以在临床中有滥用的倾向。就是说看到长期便秘的人，甚至有时候不怎么仔细辨证就用这个方子，这样就会造成经方的疗效不好。经方治病的原则是方证相应，如果患者符合这个病理特征，这个方剂绝对好用。如果不是这种病，吃下去以后或者当时有效，几天以后就没效了，或者根本就没有效果。不要以为里面有小承气汤，这么多的大黄、枳实、厚朴，还能不泻吗？就有吃了不管用的。

大阳病三日、发汗不解、蒸蒸发热者、属胃也、调胃承气汤主之、（248）

胡希恕：（音频缺如）

【按】太阳病才三日，发汗不解，马上蒸蒸发热，传变可谓迅速。不用大承气汤，以无大汗出而腹满痛故也。

【注】

①太阳病，汗法为正治。发汗后而病未解，预示着传变的可能。

②蒸蒸发热，言其热如蒸，即潮热。从内达外，为里热已转属阳明，故曰属胃也。

③无大汗出、口舌干燥，不同于白虎汤证，无腹满硬痛，故不用小承气汤，虽有潮热，但无谵语、尿硬等证，故不用大承气汤，以胃

热蒸腾发自于里，故以调胃承气汤主之，有芒硝之故也。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边是一个顶格的条文。

下面我们解读一下：

“太阳病三日”，病初得的时候是太阳病，这个“三日”，跟其他的条文里边，像四、五日，五、六日那一类的数字概念不太一样，那个数字概念都是用来表述疾病发展变化规律的，大概是在哪个时间段表证有可能发展为某某病或少阳病或阳明病。但是这个三日，它要说明一种反常规的情况，按照一般的规律，太阳病三日还到不了发展为阳明病的时候，临床当中不一定准是三天，在这儿用来强调病情严重、病势迅猛，有这种意思。

“发汗不解”，因为这个时候已经不是单纯的太阳病了，服发汗药，不单单太阳病不解，反而还会出现新的变证，就是“蒸蒸发热”。这实际上就是说体温很高啊，高热。但是“蒸蒸”在这个地方，还有里热炽盛，熏蒸于外的那种意思。表现在临床当中，这类病人就是里外俱热。

属于胃，就是说“属胃也”。在经方理论里面，特别是顶格条文里面，这是为数不多的论及脏腑的一个地方，特别是在这个方证条文里边。可是在阳明篇的提纲里边，有“胃家实”的说法，在这儿应该是有一定的呼应的关系。仅仅从字面上解读，应该是对这个条文前边论述的述症的一个病理的界定。但是实际上，这里还有另一层比较重要的意思：就是提示读者，这个调胃承气汤证跟那个白虎汤方证，白虎汤类的方证，要加以鉴别。

如果单纯地从病理上看，调胃承气汤和白虎汤证，它们的病理都是里热证。虽然在虚实倾向上，它两个多少有一点点区别，但是区别也不是特别大，都不属于典型的实证，也不属于非常典型的虚证。如果跟栀子豉汤比，这两个方证都属于实证；跟大小承气汤证比，这两个方证都属于虚证。所以说它两个从病理上说，比较接近。而且这两

个方证，都可能出现高热，这说的是“蒸蒸发热”，或者说“潮热”这一类的。但是两个方子在临床应用当中，它实际上存在着质的区别，这两个方剂之间没有替代的可能。谁也解决不了对方的问题，没有替代的那种因素存在。

从方证上比较，调胃承气汤有“便秘腹满”之类的腹部症状，白虎汤证这一类的症状就比较少。

如果从疾病的范畴上来比较，有应用调胃承气汤的机会的现代病当中，有很多属于胃肠、消化道那些疾病；而白虎汤证这一类的疾病相对的就少一些。

这个条文论述的是一种以消化道内的病变为主的一种中医称之为“温病”的急性病变。就是因为这一类的疾病，大部分涉及到胃肠内的一些病变，所以说这个地方用了“属于胃”。

伤寒吐后、腹胀满者、与调胃承气汤、（249）大阳病、若吐、若下、若发汗后、微烦、小便数、大便因硬者、与小承气汤、和之愈、（250）

胡希恕：（音频缺如）

249 条：

【按】吐后，胃不和腹胀满，不要误为大实满，而与大承气汤攻之。吐后气逆，胃常不和，少于调胃承气汤和之则愈，乃常法。

【注】

①腹胀满，乃吐后气逆而胃不和的表现。吐后，胃中实满之病因已有所去，与大承气汤证的大实大满显然有别。

②阳明病胃家实，有热实（里热充斥）、内容物毒实（如燥屎、宿食等内容物毒变者）之不同，程度亦有很大差别，为证表现也不一样，所以三承气汤各有其特定的适应症。大实、大满、大痛、大热者，大承气汤证；胃不和，调胃承气汤或小承气汤证；里实胃不和、以热为主者，调胃承气汤证（如上条）；实满腹胀为主者，小承气汤证（如下条）。本条表现是腹胀满，按常理应予小承气汤，所以予调胃承气汤者，盖因吐后之腹满乃胃气不和也，和胃则愈。

250 条：太阳病，吐、下、发汗后，由于津液亡失，胃中干而不和，故微烦。若小便数，益使胃肠枯燥，大便硬结不通，可与小承气汤，和其胃气即愈。

【按】此太阳病误治而转属阳明病者。里热不甚，故只微烦。虽大便硬，不宜大承气汤猛攻。虽有脾约证，但后者虽十日不大便无所苦，而此则微烦，故不用麻子仁丸而用小承气汤。辨证必如此入细，用药方能恰到好处。

【注】

①太阳病，吐下是非法治疗，发汗有当与不当，若发汗不当而病不解，邪乘虚入里，则转属为阳明病。

②微烦，尚未至大烦，乃邪热入里的反映。热入于里，斥津外排，故小便数。小便数，津液亡失，因而大便硬（亦可致烦）。

③大便硬，故宜小承气汤，以枳实、厚朴消胀去满有余而攻下不足。调胃承气汤以芒硝去热，虽芒硝、大黄合用，但有甘草，下之并不峻猛。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降一字格排版条文。

这一段条文在《宋本》被分为两段了，“与调胃承气汤”之前是第 249 条，之后的为第 250 条。整体来看，这两条条文论述的实际上是太阳病误治以后，发展为阳明病两种不同的情况。

先看看第 249 条这部分：

“伤寒吐后”，当然就是属于误治。这儿的“伤寒”，虽然明白白指的是阳性表实证，但是，表虚证也有这一类的情况。这个地方，可以理解成整个的太阳病而言。

“腹胀满者”，这个“腹胀满”，大家可能一听到这个症，马上就会想到第 66 条的厚朴生姜半夏甘草人参汤证。其实，这一条和那一条必须得参照着来解读。因为症状叙述的完全是一样。必须做一鉴别。

这个条文论述的是表证误治以后，患者出现了里热偏于里实的情况。而第 66 条论述的：也是表证治疗不当，出现了里虚证偏于寒的情况。虽然条文中的述症完全相同，但实际上这是两种不同的疾病。那么临床当中这个“腹胀满”，也是有明显区别的：这个条文论述的“腹胀满”，主要是患者的自我感觉；而第 66 条那个“腹胀满”，不仅仅是患者自己感觉腹满，同时还有腹部胀大，敲之有声那种气胀。不仅仅是自觉证，还有他觉证。另外这两个方证，在病理上也存在着寒热虚实上的差异。正是因为这个，所以实际临床当中，像脉象，舌象，苔象，包括其他的症状，还有好多明显的差异。这个地方等于是简论了。看看方剂就知道是有区别的。

那么在经方理论当中，有相当一部分的条文，明显都是来自于临床的，不是杜撰的，都是在临床实践的基础上总结出来的。如果我们进一步地深入思考，所有这一类的条文，实际上是作者给读者所作的示范。

他要示范什么呢？就是无论什么类型的疾病，无论何种病因，也无论有没有误治的过程，患者现什么样的方证，你就可以用什么样的方剂来治疗。

这儿说的是太阳病误治，那么其他的病误治了以后，同样的道理，现什么方证，就用什么方剂来治。

那么这个条文，论述了表证误用“吐法”以后，容易出现的以阳

性里热证为主而偏于实证的这么一种情况，并且给出了相应的治疗方法。

同时这个条文，强调了“吐法”对人体影响的一个特征：吐法伤人的里，比较容易伤到人的消化道。

那么在现实生活当中，喝酒喝多了，喝多了以后吐了，吐完了他觉着胃里边有灼热感，感觉很难受，就胃中痞满那种。如果临时解决这个问题，就给他调胃承气汤，喝一点，少喝，喝下去一会，就觉得胃里边挺舒服。一般情况下，如果对病人情况了解的话，就常这样。

对喝酒喝醉了难受的要命，我现在弄了一个方子，就是泽泻汤合上小半夏汤，再加上人参。这个治什么啊？治喝了酒以后，胃里边痞满，头脑不清醒，酒后的那些反应。如果吐了以后，胃里边有又热又满的感觉，再加上人也头晕，就再合上调胃承气汤，就挺好用。大家如果要是有兴趣的话，可以试一试。

下边是第 250 条这部分：

“太阳病，若吐、若下、若发汗后”，指阳性表证使用了攻法。那么这有一个发汗，阳性表证不就应该发汗吗？但是，这儿的发汗，应该是指那些方不对证的治疗，或者发汗太过。总之是治疗不太恰当的发汗。

“微烦”，在这儿就是指的，以里实证为主，同时又偏于里热的这么一种症状反应。

“小便数、大便因硬者”，小便数就丧失人体津液，是大便硬的一个直接的原因。

“微烦”在这个条文是一个比较重要的症状，这是跟麻子仁丸证区别的一个关键点。如果没有这个症状，就完全有应用麻子仁丸的可能。但是这儿的“微烦”，只是举的一个例子。他这儿论述的这些症状，都是在攻下的方法之后，短时间内形成的急性症，跟麻子仁丸证存在着有虚实上的区别，有这方面的区别。

如果跟麻子仁丸证的患者相比，这一类的患者没有长期体质虚弱而形成胃肠功能低下的问题。所以用不着用麻子仁丸，只能用“小承气汤，和之则愈”。甚至量上都可以调整。

得病二三日、脉弱、无太阳柴胡证、烦躁心下硬、至四五日、虽能食、以小承气汤、少少与之、微和之、令小安、至六日、与承气汤一升、若不大便六七日、小便少者、虽不受食、但初头硬后必溏、未定成硬、攻之必溏、须小便利、屎定硬、乃可攻之、宜大承气汤、（251）

胡希恕：（音频缺如）

无太阳柴胡证，指无太阳表证和少阳柴胡证。今既烦且燥，心下又硬，已四五日不大便，里实显然可见。能食为胃热，据理当可议下矣，但以脉虚，而且只限于心下硬，因稍稍与小承气汤微和其胃，稍安其烦躁，再行观察。至六日，还不大便，可增与小承气汤一升。延至六七日仍不大便，虽不能食，有似结实已甚，但若小便少者，屎未定成硬，大便初硬而后溏，则仍不可以大承气汤攻之。若不慎而攻之，必使溏泄不止，须待其小便利，则屎定硬，乃可攻之，宜大承气汤。

【按】本条脉弱与前之脉迟均属不及的脉（参见 240 条按）。阳明病见此类脉必须精心观察，慎重用药，尤其脉弱而心下硬，更当虑其虚，即有一二实候，亦不可妄试（大承气汤）攻下。先以小承气汤少少微和之，令小安，至六日再增与一升，用药何等慎重。四五日、六日、六七日、观察何等周详。治大病难，治疑似病更难，病家急躁，医者粗心，未有不败事者。

四五日至六日，虽无不大便的明文，然据不大便六七日一语，则四五日至六日未大便自在言外，古文简练，读者应仔细玩味。

【注】

①得病二三日，指始得病二三日也。刻下既无太阳证，又无少阳证，唯有烦躁和心下硬，而且已四五日不大便，可见里实已逐渐形成。胃有热当能食，今能食亦有里热，判断病属阳明当不为错。治之之法不可孟浪，一是因为脉弱与阳明脉大矛盾，这是一个主要着眼点，二是心下硬有虚的可能，即使不为虚，因只限于心下，结实还不为甚。因此，在遣方上着眼于四五日不大便而用小承气汤，少少与，微和之，令刻下证小安矣。

②过一天还不大便，仍以小承气汤增加点量，再观察之。

③若迁延至六七天仍不大便，而且已不能食，里实肯定已很重，是否就可与大承气汤攻之呢？不行，得看大便是否确实已硬再作定夺。若小便少者，大便未定成硬，或初硬后溏，此时与大承气汤攻之为时尚早，强攻之则溏泄不止也。

④小便利者，尿定硬也，乃可以大承气汤攻之。

【按】烦躁一证，从里热能食来看，当为热烦，而非虚烦。此躁亦因实也。

本条可作为仲景治病周详观察、谨慎用药。辨证施治的一个很好的范例。着眼于辨屎硬而以大承气汤攻之者，即使无潮热谵语，亦必有或满、或胀、或痛之苦，这是需认真体味者。

李冠杰：这条文在《康平本》是降两字格排版的条文。

这个条文分析来分析去，它不像顶格和降一字格条文论述的那么精辟，总是感觉有些地方不到位，但也没有什么原则性的问题。按照字面意思，能接受的就尽可能地去接受。它也是从实际的临床体验给出的一个解决办法，我们可以作参考，也可以去斟酌，从中汲取更多的东西嘛。

解读一下：

这条实际上论述的是阳性里热证。在这种病理状态下，人体偏于

虚又存在停饮证的情况。阳明病本来是机能偏于亢奋的一种疾病类型，通常情况下用攻下法治疗比较合适；但是如果同时存在着人体虚弱的因素，或者伴有其他类型的疾病，就不能贸然的使用攻下的方法。实际上这条论述的两种情况都不外乎这个意思，但是具体情况有点区别。

第一种情况：“得病二三日，脉弱，无太阳柴胡证，烦躁心下硬”。虽然病程不算很长，但是已经陷于弱脉，说明人体本来就有虚的因素存在，可是症状反应上既没有太阳病，也没有少阳病的症状存在，这个时候主要表现“烦躁、心下硬”，这说明是阳性里实热证的症状反应，既心烦又心下硬嘛！一直到了“四五日”的时候，患者还是能吃（能吃就跟热有关了），治疗的时候就少少给“小承气汤”，就是从量上控制一下，暂时让病情先缓和缓和。缓和了以后再观察，如果大便还是不怎么通（言外之意是说没有出现其它的变证，或者没有其它的不舒服，它有“小安”嘛），这个时候可以用小承气汤的原量来治疗，就是给一升。这儿的言外之意，也就可以痊愈了。

第二种情况：“若不大便六七日”了。这个地方到底是接在前边，还是接在六日不大便之后？怎么接也不会有什么原则性的问题，所以它论述的有点比较模糊，按照它的意思来理解就行了。如果六七日仍不大便，就要视具体的情况来处理了：

小便少的，说明同时还有停饮证，既有停饮又有里实证，已经影响到了吃饭，同时因存在停饮的因素，大便也只能是“初头硬、后必溏”，到不了用大承气汤的程度。有停饮证的情况，一般用攻下的方法不太好，除非紧急的情况。所以它这儿说不能攻，“攻之必溏”，给出的办法就是先利小便，等到大便硬了再用大承气汤。

实际上这个地方论述了两种阳明病里比较特殊的情况。就是说有人体虚，或者有停饮这类的因素存在，用攻法就要小心一些，大概就想说这个意思。像第二种情况，它本来有里实证，又有停饮证，明显

到不了用大承气汤的程度。用了利小便的办法，先把体液代谢不好的问题治疗了，它就成了大承气汤证，言外之意就是这个意思。那这等于把轻病治成重病了，像是人为的造成大承气汤证，再用大承气汤治疗。其实，这类情况不单纯的利小便，利小便的同时加上小承气汤，根据症状合方应该完全可以，大家临床实际都会这么选择的。但是原文既然这样写了，在临床中大概也是一个成功的经验，值得我们借鉴。

伤寒六七日、目中不了了、睛不和、无表里证、大便难、身微热者、此为实也·急下之、宜大承气汤、（252）

胡希恕：（音频缺如）

【释】目中不了了，谓视物模糊不清也，睛不和，谓眼仁暗无光泽也。伤寒六七日，其人突然目中不了了，睛不和，无发热恶寒的表证和大实大满的里证，虽只大便难而身微热，此热实于里，为候殊恶，虽外迫尚微，但上攻甚烈，病势凶猛，是需急下，宜大承气汤。

【按】热实极于里，迫于外而为身大热、汗出等，亢于上，波及头脑，而为烦躁、谵语等。本条所述系后者。伤寒表证突然罢，里实诸候不待形成，竟出现目中不了了、睛不和的险恶证候，其来势凶猛，传亦迅急大有不可终日之势，哪得以大便难、身微热再行观望之理。急制其变，唯有釜底抽薪，以大承气汤急下之。

【注】

①伤寒六七日，当是传里之期。目中不了了，睛不和，皆血液、津液不足以荣养目系，是热亢于上至极，为证凶险。

②无表里证，既无表证，亦无大实大满的里证。外迫表现虽微（身微热），但里亢上攻之势重而急，且大便难，故曰此为实也。

③不管大便硬与不硬，均当急下之，不可顾虑。

【按】这是急下存阴的大承气汤证之一。看来不像重病，但确

是不得了的症状。

李冠杰：这是一个降一字格排版的条文。

下边我们解读一下：

“伤寒六七日”就是指的患太阳表实证，已经天数比较多了。这其中就含有病情比较重，并且有进一步发展的可能。

“目中不了了”这是古人的一种说法，就是视物不清，看东西模糊，就是这一类的。

“睛不和”，指的就是眼球活动不够灵活，目光呆滞，也算是一种症状吧。人体的眼睛，它是一个视觉器官，一般情况下，人体内部发生某些病变也好，发生某些变化也好，对于眼睛的视力和眼球的转动，一般都不会有明显的影晌。比如四逆汤证，也算是一个重病了，也是人体整体的机能处于沉衰的状态，在这样的病理状态下，也很少会出现这一类症状，眼睛看东西看不清了，眼球转动目光呆滞，眼球转动都不够灵活了。这说明这个时候的人体他所患的病，已经是危急重症。

“无表里证”，有两层的意思：一个是说这个时候的人体已经脱离了表证的病理阶段，他已经不会有典型的表证的症状反应了。表证是在人体当中属于比较浅层次的疾病，如果进一步发展成更重的病的时候，往往表证就会消失了。我们比较客观地说，这种表证的消失，并不是表证痊愈的一种象征，只是人体没有能力在表证阶段与疾病抗争了。

实际上这种情况，在我们现实生活中比比皆是。大家几乎每天都能看到的用抗生素来治感冒，都是这么一个过程，本来人体还有能力在体表这个层面上与疾病抗争表现出感冒的症状，发热、发烧、咳嗽、恶寒，像这一大堆的表证的症状。美国前一段时间闹 N1H3 病毒，也是甲型流感，在报道这个的时候，就说出了一句非常客观的话，就是说目前对于感冒，最有效的治疗手段就是流感疫苗。言外之意是什

么？没有有效的手段。流感疫苗也不是治疗感冒，是一种预防性的，不能治疗。实际上抗生素在正规的医院里边，按照正规的用药程序的话，它是不允许用来治感冒的。但是现在大家都在用，也确实实用了它以后，绝大多数人的感冒症状会消失。怎么消失的？它把人体的抵抗力进一步地降低，让你没有能力在体表与疾病做斗争了，感冒症状消失了。这是顺便延伸了，这是第一层意思。

第二层意思呢，就是说虽然有“大便难”的症状，却没有明显的腹部症状，比如腹满拒按这一类的腹部症状。有的读者把这个地方的“无里证”解读成是没有半表半里证。因为在原文的论述中有的地方把小柴胡汤和大柴胡汤证，也可以分外和里，想当然也可以在表证和半表半里之间，把半表半里证视为是里证，这样看好像是比较合理，但是实际上这个原文的作者本意，他应该不是这个意思。

第一，从这个条文的述症和治疗方剂来看，没有半表半里证，没必要再去强调有无半表半里证，这儿没有必要去隐含这么一层意思。

第二，条文论述的是一种初得的时候为太阳病，因为太阳病没有得到合理的治疗，病情发展迅猛，就是突发为危症一种情况。所以说这个时候如果没有明显的腹证，这是完全有可能的。前边有一个具体的日子，但这个日子没有必要把它看成特别的，不一定非得绝对的就那么几天，十几天也没有关系。但是在这些天里边，有几天实际是表证的阶段，它在变化成里证的时候，还要经过一个过渡期，等他成了里实热证的重证的时间，他应该是没有这个时间，因为病势发展的很快，里实的那种情况还不足以很明确的反映出来。但是这儿已经强调了“大便难”，最起码得有几天解大便不容易。所以这个“无里证”，本意在强调此时的人体除了“大便难”一症以外，没有典型的大承气汤证的这个症状。可以这么解释的不多。如果严格的按照经方理论的标准来衡量的话，这个“无里证”确实有些不妥，“大便难”本身它就应该是一个比较典型的里证。或许这个无里证，也包括白虎汤证的

里热证，也不是说很明显，后边有，也可能有这一方面的意思。但是无论如何，这里很明确地提出来“大便难”，也就是比较客观地跟你说，我这个“无里证”里边不包括这一项。

“身微热者”，虽然有热，但是仅仅是微热。列举这个症状，他重点在于强调体温方面也没有大承气汤证的“潮热”之类的典型的症状。而且在一般论述的情况下，那个白虎汤证有热，也不至于说“微热”，也是比较重的。

本条论述的就是大承气汤证的一种比较特殊的情况。因为一开始是表证，后来发展得非常快，到了形成了阳明里实热证的时候，病势发展得非常得迅猛，还没有来得及出现那些典型的大承气汤证的症状，但是已经出现了“目中不了了，睛不和”这一类的危重的症状。有治疗方剂在后边，所以说与此同时应该还有一系列的阳明里实热证的一些反应，那么这一类的反应，在其它条文里边都有论述。这个地方强调了一个无里证，没有典型的大承气汤证的症状。其他比如舌象、脉象、患者的自我感觉等，肯定会有一派的热象和实证，这些都没有进行细论，他把论述的重点，放到了强调那些个非大承气汤证的症状反应上，像“目中不了了者，睛不和”，这在大承气汤证的其它地方都没有论述。这个地方特意来强调它，就是说用来警示读者，你遇到此类的患者，千万不要延误。你要是一旦延误了就有可能出现医疗事故。所以它说“急下之”，要用大承气汤来急下之。

阳明病、发热汗多者、急下之、宜大承气汤、（253）

胡希恕：（音频缺如）

【释】阳明病，蒸蒸发热，大汗如流为热盛由里蒸腾于外，津液欲竭之象，应急下其热以救津液，缓则无及，宜大承气汤。

【按】壮热内迫，津液外越，故发热、汗多如流。如不急下，津

液立刻枯竭，恶证蜂起，必致不救。

【注】

①发热，非一般的表证或里证，必为书中形容的大汗、潮热、蒸蒸发热也。

②汗出多，亦非一般的汗，乃异常的大汗如流、淋漓如雨者。津液销铄，损失很快，此亡阳（津液）之汗也。

【按】阳明病里热之证，书中多条提到大热、潮热、蒸蒸发热。阳明病法多汗，书中亦有多条为证。是否一见发热、汗多，即和本条等视而论呢？不是的。其可为大承气汤的适应症，但未必如本条之危险。“急下之”的急字，深含寓意也。本条乃急下存阴的大承气汤证之二。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降两字格排版的条文。

下面我们解读一下：

“阳明病”，在这儿指的阳性里实热证典型的症状反应，或者这就是一个真正的阳明病。

“发热汗多者”，是患者表现出来的一种突出的症状。咱们不妨和前面那个条文联系一下，前边的条文表现出来的突出的症状是什么？“目中不了了，睛不和”。那么这儿的突出症状是什么啊？“发热汗多”，不仅仅是汗出，而且是汗出很多。这个“汗多”，我们可以视为是大汗淋漓之类的，就是汗出特别多的这种情况。如果一般的汗出的话，也不至于特别用了一个“汗多”这样的字眼。那这也可以视作是大承气汤证的一种表现形式。在其他条文里边有所论及，但是都不是以这一类的症状反应为主要的突出症状。

实际上，在临床当中这一类的患者，也不仅仅就是一个发热汗出多，他也还会有明显的里实证的症状反应。而且，它跟白虎汤证的发热汗出，也会在程度上、患者的自我感觉上有一些差别。

这个条文论述的，其实也是一种危急重症。这个汗出，不单单是

发病急，而且量非常大。如果一旦拿不准，用错了方子，就可能会致人脱汗而发生危险。所以这儿呢，也在强调要“急下之”。

发汗不解、腹满痛者、急下之、宜大承气汤、（254）腹满不减、减不足言、当下之、宜大承气汤、（255）

胡希恕：（音频缺如）

254 条：

【释】发汗不解，指太阳病发汗后不解，竟直传于里。腹满且痛，可见结实已甚，传变迅急，不可等闲视之。须急下之，宜大承气汤。

【按】以上三条均为病猛剧，传变迫急，看似不重，稍有延误，祸变立至，故须急下之，读者宜细玩而熟记之。

【注】

①发汗不解，指太阳病发汗后而病不解。这里要特别注意，是表证不解还是里证不解？是里不解，而且还向严重的程度发展。如果是表未解，则正邪仍恋战于表，传里必不致如此急剧也。

②腹满痛，为大实、大满、大痛，不但面积大而且痛重，是表证急剧传里的表现。

【按】此急下存阴的大承气汤证之三。

255 条：（音频缺如）

【释】此条承上条腹满痛而言，虽以大承气汤急下，但腹满不减，即有所减亦微不足道。此为实，还当下之，宜大承气汤。

【按】《金匱》曰“腹满不减，复如故，此为寒，当与温药”，与本条所述正成对子，宜互参。腹满不减，减不足言，若属一般的实满，用厚朴三物汤足矣，当无需大承气汤猛攻。本条盖病毒重剧，结

实至极，非一击而能收功。除恶务尽，故须再下。

【注】

①腹满有虚实之别。腹满不减，减不足言，为实满，腹满时减，复如故，为虚满。临床见上午腹不满而下午满，或醒时胀满而寐时较好者，皆属虚满。

②腹满不减虽属实，但不定必用大承气汤攻之，临证还当参照余证而用适方。本条用大承气汤在于腹满不减，胀的厉害，且有增无减。

【按】读本条，当明其两条含义：①服大承气汤后病去甚微，有是证在，仍可服大承气汤。②腹满胀的虚实辨证之法。本条不用急下之，而用当下之，提示辨证要细微，当求其本质也。

李冠杰：这两条在《康平本》是同一段条文，也是降两字格排版的条文。

“发汗不解”。在条文中没有把发汗的目的交代清楚，没说发汗之前是什么情况。“发汗”肯定是人为的一个治疗过程，为什么发汗？是表证还是误发了汗？是表证，发汗方不对证还是发汗不当？没有交代，就只是说“发汗不解”。上边的第253条的内容是“发热汗多”，绝不会再有施以汗法的道理，在意思上不会是承接这一条的。如果它本来是太阳病，应该发汗的，但是发汗不当并造成了下面的变证，但是又没有明文，像这种条文，现在只能按照它字面的意思，尽可能的客观解读，让我们从中获得最多的受益点。

“腹满痛者”是指因为误汗造成人体发生了严重的阳明里实热证，表现出腹不但满，而且还痛。从后面的治疗方剂可以知道，这儿应该还有一系列里实热证的症状反应。它比表证发展为阳明病还要迅速，因为里边有“发汗”的过程，所以它变为大承气汤证非常得快，像大便不通的症状或者还未表现出来，但是现在已经表现出“腹满痛”——腹内已经结实了。前边有一个误汗，可以使人体的津液损失，人体的消化道内又出现了结滞的里实热证，所以这样的病情发展比较

快，也不能再延误，必须要用大承气汤“急下之”。如果延误了，可能会很快地发展为危急的重症。

接下来是第 255 条：“腹满不减，减不足言”。在《康平本》里第 255 条和第 254 条是同一段内容，它们之间肯定是有联系的。这个地方“腹满不减”前边也没有交待什么背景，应该是指的第 254 条论述的情况。这就成了服大承气汤以后，“腹满不减，减不足言”，腹满有一点减，但是程度非常轻微，“不足言”就是说微不足道，甚至都可以忽略。但是没有用“急下之”，而是用了“当下之”。结合前边的第 254 条，让人感觉的意思就是还应该继续用大承气汤来下。实际上果真是这样的话，也只能再服大承气汤。

在《宋本》中这条单独列成了一段。这应该是王叔和在第二次整理时，特意把它给断开了，恐怕他自己认为还有别的意思，或者说不能把它看成是一段而分开了。当初写成一段或许有上面咱们分析原因，把它又分开必是另有考虑。从王叔和做的调整里，我们能感觉到这个“腹满不减”，或许它另有所指啊。在《金匱要略》“腹满寒疝宿食病脉证治第十”里，这条又重新出现了，内容几乎是完全一样的，只是“当下之”变成了“当须下之”。《金匱要略》里没有第 254 条了。所以《康平本》样式也是一个事实，后来他又改成了《宋本》，又在《金匱要略》里把第 254 条完全抛开，第 255 条又单独的出现了。

所以，回过头再看“腹满不减、减不足言”，应该是初得病时，就表现为“腹满”这类里实证的症状反应，按一般的下法治疗以后，比如用小承气汤证治疗，“腹满”的程度有一点减，但是减得非常轻微，就是“减不足言”。这样的情况再用大承气汤攻下，比较合理一些。但是它没有这么交代，咱只能牵强附会得把它解释通了。

这条论述的也是大承气汤证中一种比较特殊的表现形式。它的症状反应是以“腹满”为主，其他的里实热证必然也有，但是没有腹满症突出。而且这儿已经用其它的方剂下过了，效果又收效甚微，说明

里实证已经比较严重了，所以它的经验也是用大承气汤来攻下。

阳明少阳合病、必下利、其脉不负者·为顺也·（注）负者失也·互相克贼·名为负也·（论）脉滑而数者、有宿食也、当下之、宜大承气汤、（256）

胡希恕：（音频缺如）

【释】本条应读为“下利，脉滑而数者有宿食也，当下之，宜大承气汤。”脉滑而数，为里实有热，下利见此脉，为有宿食的缘故，当下之，宜大承气汤。

【按】阳明病本不下利，由于木来克土，故反下利，因以阳明少阳合病冠之。此句和“其脉不负……名为负也”一段文字均为附会五行家言，不足为法，亦可能是后人所附，宜去之。

本条所述下利，即指今之肠炎、痢疾而言。中医治病重在辨证，其以太阳病证出现者，即依汗法解之，以阳明病出现者，即依下法解之，其以少阳证出现者，即依和法解之。本是活泼泼的，不存任何成见。治痢如是，治它病亦无不如是也。开头的这句话不是本条辨证的依据。

【注】

①阳明少阳合病，指既有阳明病的不恶寒、但热等，又有少阳病的口苦、咽干等。必下利的必字，一定是也。

②这段文字是以五行理念来解释阳明少阳合病必下利；阳明属土，脉大；少阳属木，脉弦。若大盛于弦，即木未克土，此为顺（不负）也，不致下利；若弦盛于大，即木来克土，此为负，土被木克，则必下利。古人论病是先由经验掌握治病规律，后求解释。在这个长期的探索中，当时兴什么学说，就尝试用什么学说来解释。本条用五行学说解释，显然是十分牵强的。照仲景书惯例，第一句应为“少阳

阳明合病”才是，凡此者，疑为后人所附。下利是本条为证，须知。

③以脉来辨里有宿食，《伤寒论》中有本条，《金匱腹满》中有“脉数而滑者，实也，有宿食”，“脉紧如转索无常者，有宿食也”，“寸口脉浮而大，按之反涩，尺中亦微而涩，故知有宿食”。阳明病里有热，开始本应能食（参见 197 条），但随着里热的伤津烁液，食反不得消化而逐渐成为宿食。如果还没有结滞而影响气血运行，则其脉滑数，若影响到气血运行，则必不滑而涩也。若大便硬，腹气不通，已大实满，脉不当滑矣。本条虽有下利，但脉滑而数者，有宿食也。

【注】阳明少阳合病句非本条的本质，在治疗上亦不足为据。下利，脉滑而数者，实也，以其为宿食，故治从阳明，宜大承气汤。若其人挟有少阳证者，当选大柴胡汤矣。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降一字格排版的条文。

解读一下：

这个条文虽然内容不多，但是文字非常复杂。其中不单有嵌注也有旁注，而且注解的观点和正文及经方理论都存在着明显的不同。

咱们先看看正文：“阳明少阳合病，必下利”，这儿的“必”字应该当做“若、如果、假设”来理解，就说阳明少阳合病如果出现下利的，应该这么理解。这儿的少阳病，患者可能存在某些少阳病的症状反应，也就是在阳明病的同时有某些少阳病的症状或者近似少阳病的症状。这个时候的“下利”，在临床表现上与通常的腹泻有所不同，不一样。不单单会伴有腹满、腹痛、拒按这一类的症状，而且所下之物多为清水，实际就是大承气汤证中所谓“热结旁流”那一类的情况。

正文接下来“脉滑而数者，有宿食也，当下之”。这儿的“脉滑而数”，在实际临床当中并不一定是个必见证。实际上大承气汤证的脉象相当复杂，绝不会仅限这么一种脉。这儿的“脉滑而数”，既可以看做是一个易发证，容易出现的症状；同时也应该理解成这是作者用“脉滑而数”来示意人体有里实热证的病理状态。“有宿食也”，

可以理解为对上面所论述的做的病理界定，同时也是对“脉滑而数”的进一步诠释。说明这个条文论述的是在里实热证的病理状态下，发生了严重的消化道内的积滞。虽然表现为下利，但是还要以泻下的方法来治疗，所以他这儿说“当下之”。

这个条文当中的注解内容不仅仅有两种，而且从理论上、从叙述上，都让人感觉和其他的注解有所不同。虽然，这两段注解，一个是嵌注，一个是旁注，注解的形式不同，但是他们的理论观点是一脉相承的。而且论述的是同一个问题的两个方面，都是以五行的理论来诠释经方理论。真实的意思就在于将“阳明少阳合病、必下利”这段原文，解释成是五行生克的结果。像这种解释在经方里边，特别是顶格条文里边，实际上在降一字格条文里边也没有类似的论述。这跟经方理论实际上是相悖的，经方理论里边没有这一套东西。

但是这儿呢，又捎带出另一个问题：他为什么在这儿加嵌注？这个问题我们不能轻易地武断地下结论，但是我在这儿给大家提一个思考的方向。凡是加嵌注的条文往往都存在着上下衔接不是特别顺畅的情况。有些条文把注解抠出去之后，把它联系起来看，它不是一个完整的条文。当时的年代因为战乱，混乱不堪，王叔和在得到这本书的时候，已经是个失散了的版本了，而且从有些条文缺字来看，许多条文都不是完整的，所以出现这类的情况。咱们就只能这么理解。

但是，有一个问题必须得证实，通过这个条文我们也能明显看出来，《宋本》把所有的注解都窜入到正文以后，这个条文就是一个非常的典型了。它不单单是歪曲了经方理论，而且也严重误导了后世的读者。为什么？因为窜入到正文以后，后人不知道它是注解内容，所有人都把它当作经方理论来解读。就这种误导，如果今天我们没有《康平本》，即使有人在这个地方读出一些异样来，也不可能在学术界成为主流，像胡老一样。许多地方，胡老在阳明篇的小结里面，就对“正阳阳明、少阳阳明”那些分类，他说的轻描淡写，这只是一种

说法而已，你看他读得多么准确。那就不是经方原文，应该说不是经方原文的东西，不是一个作者的东西，他就品出来了。到目前为止，我们看到的所有的经方的学者里面，解读经方理论，最贴近《康平本》的，最贴近这本书原貌的，就是胡希恕先生。其他人都是个别地方能认识到了，整体来看，很少有人能读到胡老的这种深度。指的是准确性，准确到这种程度。

那么上面这五条条文，也就是 252、253、254、255、256 这五条条文，都论述了什么？论述了大承气汤证的一些比较特殊的情况。这一类的条文，因为涉及到了具体方剂的临床应用，而且又大多数来自于作者自身临床实践经验的总结，这都不是空穴来风。所以，凡是这类的条文，无论论述得好，论述得不好，我们去客观地解读；论述得好，我们就深入地全面地去解读。但是都应该给予高度的重视。为什么？因为这都是从临床实践当中来的。从这个基点上来说，都符合经方理论的精髓。而且我们应该把它看成经方理论有益的补充。以大承气汤为例，大承气汤常见的症状反应，在顶格条文里面都有，几乎方方面面都论述到了。这些作者又对顶格条文没有论述的那些不常见的情况，加以论述，这应该对我们来说是难得的一些好的、临床实践的经验。

这些条文，有一个共同的特点：如果按照大承气汤证的经典条文的述症来对照的话，这些条文没有任何一个条文的述症可以构成使用大承气汤的证据。但是，这些条文论述的都是在承气汤证的病理基础上，以这些条文里面论述的症状，为突出的症状反应的这么一类特殊情况。像第 252 条：“目中不了了，睛不和”。我们退一步说，假如我们不知道这个条文，没人告诉你这个人舌红、苔黄、苔干，口干舌燥，脉洪大，他有一系列的阳明里实热证的症状反应。他也没有潮热、大便不通也不是特别明显；或者有大便不通，但是没有潮热，也没有手足汗出这一类的症状。他有“目中不了了，睛不和”这个症状，

那么你用什么方法来治呢？如果从这个角度来想，这个条文的价值就凸显出来了。拿我们今天临床来说，你要真碰到这样的病人，要是想不到，那是很危险的；要是想到了，你再去斟酌可不可以用大承气汤。危险的是你想不到，想不到就把病给耽误了，是不是？这是急重的。但是这类的条文的作者，跟顶格条文不是一个作者，论述当中，有的甚至在理论上跟经方理论还有较大的出入。我在准备这些资料的时候，我把这些东西串起来的时候，也是经过反复推敲的，你得讲的通。总是感觉这些条文比较另类。

为了能够更好地去理解这一类的条文，我给大家找了一些医案，咱们结合临床来看一看，能帮助我们理解这些条文。

咱先看第一个医案：这是一男性的患者，21岁，于八个月前患重感冒。经治疗以后，有一个后遗症，眼睛蒙眬，视力不佳，同时伴有口干舌燥喜饮，小便短赤、大便燥，脉大而实。医者就根据第252条那个精神，他说“仲景启示以大承气汤试之”。他也拿不准，因为这哪象大承气汤证啊？但是，有这样论述，试试吧。最后“不料，应手起效，两剂而愈”。你看这个医案就很能说明问题。在临床当中确实有类似这样的东西。

第二个医案，是个女性患者，70岁，秋季的时候患腹泻，老治不好，后来发展到“事甚危急”，很严重了。诊查：脉细而弦，舌苔白厚，泻下的多是水色清绿的排泄物，一天要大便十余次，还同时表现为“心下满，腹胀如鼓，按之硬痛，噫气多（也就是暖气），时呕吐，呕吐多量的绿水，咽干，思食冷物（就是喜冷食），小便赤而少”。那么他就给她大承气汤。服了一剂以后，第二天早晨，她就泻下了溏粪半桶，其中有许多硬块，泻完以后，诸症皆减。后来，考虑她年龄比较高，又以白虎汤善后。

第三个医案，一个男性患者，47岁，三伏天，腹中绞痛，下痢红白，红多白少，里急后重，一夜间，解大便三十余次。但这个人形

体壮实，面色红，有垢腻，就是脸上显得不是很干净，口渴喜冷饮，小便短赤。后来，给他大承气汤加玄明粉。服一剂后，下利就减为一晚上只有四次，里急后重，也大减。再服一剂，泻下就变成两次了，诸证都有所减。最后，用葛根芩连汤善后。

通过上边这三个医案，咱们就有这种感觉了：实际临床当中，大承气汤证的症状反应，多种多样。而且有时候，所现的症状与条文的论述出入比较大。但是，通过这些医案，咱们也看出一个共同的规律，那就是：都必须符合阳性里实热证的病理特征。

这儿顺便跟大家提一下，我们现在的人，这么强烈的里实热证的症状反应就比较少了。

病人无表里证、发热七八日、虽脉浮数者、可下之、假令已下、脉数不解、合热则消谷喜饥、至六七日、不大便者、有瘀血、宜抵当汤、⁽²⁵⁷⁾若脉数不解、而下不止、必协热便脓血也、⁽²⁵⁸⁾

胡希恕：257 条：……没有明显的“发热恶寒”的那个表证和阳明病这个…啊，啊…“身热汗出，不恶寒但恶热”的这么，啊，这么一种证候。就是没有明显的表里证。“发热七八日”，就是发热，这个在临床上咱们很多呀。一会儿我给你们讲一个病例，啊。“虽脉浮数者”，咱们都说这个浮主表，浮也主热呀。虽然脉浮数像表，热在表似的，是吧？“可下之”，这个也要用泻药，这个属于里热。假令已下，啊，脉数不解，就说这热也是不退了。合热则消谷善饥，那么我们吃了这个泻药，这个热应该退。假设要不退呢，肯定是瘀血。这个瘀血合热呀，能嗜食，合热则消谷善饥。所以有这一句话呀，这个

瘀血证，咱们这一个，啊，治这个治中消证，啊，嗜食证，有瘀血的问题也不少啊。这个就说明这一个。他有瘀血，要是有热，啊，瘀血与热合，这个人绝对能吃东西。那么泻之后了，到六七天还不大便，这人又能吃东西，肯定有瘀血，宜抵当汤。这一阵儿你就是祛瘀就行了。这一个说明什么问题呢？就说明，日久发烧不退。这在临床上也常遇着，啊，这一种发烧不退呀，一般这是里热，吃泻药就可以治疗的。那么也有日久不退的这一种…这一种发烧，有瘀血。瘀血他也没有明显证候，不像我们讲的那个，头前儿讲“其人如狂”啊，啊，也没有这个证候。你开始没法看出瘀血来，开始只能吃一般的这个…啊，根据他这个…病的情况而用一种适应的泻下方剂了。我们最常用的就大柴胡汤，啊，热得厉害加石膏。那么这些药吃下去之后了，还热，脉还数。不是说脉不浮了，光数了，这注家这么瞎闹。他这个脉数就指着上边这个整个的脉，还是浮数，啊。而且热也没退。这一个肯定不是个单纯的里热了，有瘀血的关系。这一阵儿你问问他吧，如果他要是能吃，这是瘀血的嗜食症，啊，合热则消谷善饥。这是瘀血，瘀血就是…瘀血这个东西它就是蕴热，啊，咱们头前儿也有，讲那个抵当汤的时候。伤寒，啊，发热他不解，停水他不解，有瘀血他不解。如果少腹满，小便利者，这是有瘀血的问题用抵当汤，头前儿就有。因为这个里气不通啊，影响外热不除的。那么这一个时候，啊，过六七天又不大便了，这是里实啊。里实他就瘀，有瘀血的问题呀，用抵当汤，你不…你不能再用其它的泻下药了，这是瘀血，所以再吃抵当汤就可以好了。这一个病啊，我可…啊，根据这一条，我治了很多，很多这一种高烧久久不愈的病，太多了。我记得，我上一次给讲那一个，啊…柴胡剂，我还提到这个问题，啊。最多呢，有五十多天，这人高烧，那都 40 上下度，老是这样子。这是北京一个大医院。他们就是那一阵儿就想什么了呢？这个高烧不退，你说是抗生素啊，输液呀，这西医这一套法子都用了，也不好。不好了，他们就想这个癌了，

啊。这就是把这个各大医院这些专家都请去了，我总之也去了。嘿，嘿，嘿。他们一会诊，肯定是癌，你看这个去烧的法子都用了。哈，可把这个老头子吓坏了，这个老头儿是一个，啊，老专家。他一听是癌他还不害怕？嘿。我是最后看的，因为那个主治大夫是我一个朋友的孩子，他寻常就有病他也老找我。最后了他跑我家去了，他说这个，哎呀，是癌呢，现在也查不出癌细胞。嘿，嘿，嘿。他脖子上有，有一个小包啊，也给他做切片了，也不是。嘿，嘿，嘿。那就是淋巴，什么，啊，就是淋巴结，他这个给…给…给…给做切片。我当时就说呀，我说这一个呀，就是感冒，啊，大概是这个情形。后来我就给他吃的大柴胡加石膏，一副药他烧就退了。你想，五十多天。这我治可多了，用这一种，就是根据这一条“虽脉浮数者”，可这个时候，舌苔绝对黄”而且这个人呐，这都是有胸胁满恶心，不能吃东西，舌苔黄，这个病太多。我在咱们这个门诊上，这是在那一边的时候。也是有一个 301 住院的一个老…老首长。他也是，一个月他的高烧没退。后来他生气了，他搬出来了，跑到半拉那个什么，这个总后…他是外省的，后来来找我，也是吃一副药就好了。这个东西很好治。可是这一个呀，脉浮数，还心思他是表证，是不对的。所以他这个，这个书啊，大家还应该好好读，啊。他有些这一个，啊…的确他是这个东西…通过实践的东西。一方面呢，啊，当然六经八纲那要辨的，那是原则上的东西呀，最…最终要辨方证。你像咱们讲那个大承气汤、小承气汤、调胃承气汤，都有它一个适应的一定的证候，一定的一个，啊。你这个你得掌握，你不掌握在临床上就不行。可是该下，药用不对了一样不好病。下边有限了，啊。下一回呀，咱们就把它讲完，同时啊，你们也看一看，啊，把这 阳明病啊，咱们做个总结，跟这太阳病一样，咱把这个阳明病讲完了。这一个书啊，错误是有，啊。也有…咱们头前儿也提出很多。他这个传抄啊，这古人这个东西他不是有…不是一个刊印的东西。你像赵开美…你像这一个，这后世才有啊，

以前都抄写本，你看那个王叔和记那就是，这个人抄这样儿，那个人抄那样。所以这个传抄的错误的地方是有的。

258 条：这一条啊，应该和上边 257 条是一条。那一条说是这个，病人无表里证，发热七八日，虽脉浮数者，可下之。那么假令已下，脉数不解，合热则消谷善饥，至六七日不大便者，有瘀血。那么假若…啊，吃了这一个药，就是宜抵当汤了。“若脉数不解，而下不止”，这不是接着这…这一…这一节，接着上边儿“可下之，假令已下”。他可以发生两种问题：一种啊，脉数不解，啊，合热则消谷善饥，就咱们说这“嗜食证”啊，嗜食证是多有瘀血了。假若六七日还不大便，那么这是肯定有瘀血，所以他用抵当汤来主治之；那么假若…啊，下之后，“假令已下，脉数不解，而下不止”，这一个不是合热消谷善饥，啊，而不大便秘了。这一个反而泻下不止。那么这一个他是协热…协热痢了，啊。就是他这个热呀，随着这个泻药，注于大肠而为协热下利，就所以说他必便脓血也。那么这是接着上头。上头啊，我们遇着这么种病，假设发烧七八天了，那么这一个时候这个脉浮数啊，他不是表证了，不是热在表了。这个浮也主热，啊，“浮数者”就是有热，这个热是…一般说应该在里。所以他说“虽脉浮数者”，你不要认为是表热，而是里热，可以下。那么下之后呢？病就好了，他就没问题了。假若下之后，啊，脉数还是存在，数还是有热了，那么这一个啊，啊，有两种问题了：一个你看他这个下后的情况。所以中医他是处…处处讲辨证，啊。如果他要消谷善饥，这是瘀血合热的一种反应。那么他是…要是假设是这个样子，他不会大便秘的，啊。因为你不去瘀血，只是用通便的药，他是达不到这个问题了，所以到七八日还不大便，这肯定是有瘀血。这是又一段，用抵当汤。那么假令已下，而脉数不解，他这个病啊，还是在里，可是变了。他必定要发生协热痢了，他这个热在里头久了，啊，你一通大便，这个热随着泻下药而为下痢，便脓血这么种病。这是又一节儿。这一节儿下痢便脓血，头

前儿都讲过了，是吧？根据治便脓血的方法来治疗来，所以他也没出方子。这是上次啊，这一个应该并到这个头前儿这一节儿就好了，这个书啊，给断开了。大概在成无己本啊。他就是在一节，在一章里头，在一条里头。

李冠杰：这条在《康平本》是降两字格排版的条文。

在《宋本》里这一段以“宜抵当汤”被分为两条。

解读一下：

这条是篇幅比较长一点的条文，论述的内容相对也比较多。所以我们以它为例子，相关的事明确一下。要客观地解读这类条文，首先要明确一个问题：这个条文的作者不但不是经方理论的创建者，而且他的理论观点与经方理论还存在着明显差别，根本就不是一个理论体系。但是这个作者又是经方方剂的使用者和经方理论的实践者。现在号称经方爱好者的，有许多都是这种，用脏腑辨证来用经方的不大有人在嘛！最后用来用去老出事。即使不是一个体系，也不妨碍在临床中用经方，也不妨碍实践经方理论，只是用的水平及实践的层面比较低。所以这类的条文论述，常常会出现理论上的偏差，同时还有实践经验的总结，我们应该客观地来解读。

具体来看看：

条文中“病人无表里证，发热七八日，虽脉浮数者，可下之”。这是整段条文的基础证型，大致意思是说患者主要表现为发热，既没有恶寒之类的表证症状，又没有不恶寒汗出之类的里证症状，虽然脉象现浮而数，也不能认为有表证。这个作者和降一字格条文的作者都有以脉定证的倾向，所以在论述上就强调这一点，虽有这样的脉象，但是不要认为有表证的存在，这点倒也是比较客观的啊。这类的情况最后的结论是：原则上可以使用下法治疗，就是“可下之”嘛。

但事实上，整个一大段条文里接下来论述的是：上边这些情况使用了下法以后，所出现的三种不同的后果。大家看到的这不两种吗？

下面分析分析：

第一种情况，是用了下法以后疾病痊愈了，意思蕴含在“可下之”里边，就是有用下法治好了。

第二种情况是瘀血证。患者本来是瘀血证伴有里热证，却当作是里实证误诊了，错误的用了下法治疗，结果肯定是没有痊愈。

第三种情况，这个作者将单纯的里热证误诊为里实热证，也施以下法，不单单没痊愈，还产生了不良后果。

实际上条文论述的是这三种情况，而且三种情况各自属于不同性质的问题。第一种用了下法以后痊愈了，肯定有可下的症状反应。第二种用下法不愈的，属于误诊。所以“可下之”的“之”，严格说只能是对第一种情况而言。后边的瘀血证用了抵当汤，也可以称作“下之”，勉强也可以在这类里边。最后一种绝对就不是了，所以说这个“可下之”用得不是很恰当。

下边“假令已下，脉数不解，合热则消谷喜饥，至六七日不大便者，有瘀血，宜抵当汤”。大致意思是说第一段“可下之”之前论述的情形，用了下法以后疾病未除，以前的症状几乎还都在。“脉数不解”应该不是指除了脉数未除而其它的症状都消失了，至少按前面的论述，发热、脉数这类的症状仍不得解。如果仅仅表现为脉数，其他的症状一点也没有，也不能用抵当汤啊！不能机械地解读。“脉数不解”就是说以前症状反应没有质的变化。同时患者还表现为能吃，这儿是“合热则消谷喜饥”。实际上不是因为下了以后形成的瘀血，这都是久有瘀血，在用下法之前就应该有了。下了以后又逐渐出现多日“不大便”，又结滞起来了。这个时候就不能再下了，这是有瘀血了，应该用抵当汤来治疗。

接下来“若脉数不解，而下不止，必协热便脓血也”。这又是一个误治的情况，是对于第一段“无表里证，发热七八日，虽脉浮数”这类的情况使用了下法，不单单热不去，反而出现了“下利不止”，

甚至发生“便脓血”的情况，这实际上是方不对证。比如本来是调胃承气汤证，却使用了小承气汤、大承气汤，甚至是用了其它温性的泻下方剂造成的这种情况。

通过条文，可以看出这个作者无论是对经方理论，还是对方剂的应用都有诸多不到位之处。仅从条文中就能看出来，他曾经将瘀血证误诊为里实热证，用下法而不效；也曾经对里热证误用过下法，造成病人下利不止，甚至致使患者出现便脓血的情况。即便如此，他仍然轻率的得出第一段所说的“可下之”的结论，实在太轻率，不妥当，还不如分开说。但是条文里论述的“脉数”、“消谷喜饥”、“不大便”，把这三个症状作为血瘀证症状反应，确确实实是非常宝贵的临床经验。就像临床中想找有没有瘀血证，常常会问有没有“喜忘”，就是记忆力衰退了，目的就是要找瘀血的证据。

这个“消谷喜饥”、“脉数”、“不大便”都是瘀血的证据。“脉数”，瘀血证可见，阳明里热证可见；表证有发热的时候也可见。这不就是一个共同的证吗？“消谷喜饥”，阳明里热证有时候也会出现。“不大便”，阳明里热证也经常出现，在不同的病理状况下，这是都可能出现的症状。但是“脉数、消谷喜饥、不大便”三个症状合在一块，而且又用下法没治好，这不成了瘀血证了吗？虽然从理论上这都是阳明里实热的一些症状，假设想用小承气汤，再去看有没有其它小承气汤证，有一个就够了；但要是没有的话，再去找瘀血证，有一个瘀血证也就够了。这就是临床辨证。总结的这些经验，特别是“消谷喜饥”跟瘀血有关，非常珍贵。今天我们在临床中也还有很高的指导意义。

伤寒发汗已、身目为黄、所以然者、以寒湿在里不解故也、以为不可下也、□□□□□^①（注）于寒湿中求之·（259）

注：《宋本》无此五个缺字符号。

胡希恕：这一个伤寒，啊，太阳伤寒呐，依法应该发汗。那么可是发汗之后“身目为黄”，啊，这个人呐，啊，发…又…又发生黄疸了。那么这是什么道理呢？啊，这是由于，啊，寒湿在里而热不退的，啊。咱们这一个头前儿也讲了很多。所以在这个太阳病这个阶段，心下水气，表不解啊，你非先去水气不可，头前儿这个例子很多了，啊，你像桂枝去芍药加茯苓白术都属于这一个。他里头有停水，要如果小便不利，那你吃解表药是达不到这个要求的，必须兼利小便。那么他这一个病呢？也就这么个看法，啊。完了我再给讲，这一个看法古人是有一些不对的地方。那么这一个表不解…啊，这个热不退，啊，有“寒湿在里”有关系。“以为不可下也”，这个黄疸这种病啊，一般说是可下的。假若我们，啊，诊断这一个证候而不可下，他是纯粹寒湿在里。这说明什么问题呢？古人这个样子看法，这个发黄证啊，他认为有湿有热，所以这叫做瘀热在里嘛。瘀热在里，这个热与水他叫做瘀热，瘀血也叫瘀热呀，啊，这个…这个热呀，瘀于血叫瘀血了，也叫瘀热在里了。那么他瘀与水，他这个水和热，啊，相恋。这后世这个…这个病例上有了是了，所以热以水为巢，啊，热这个“水以热为巢，热以水为据”，这王孟英医案上常有这些话。这是个现象的问题，啊。那么如果有水，你不利水，这个热去不了。这是一个…啊，在这个，这是个事实。那么古人也解释这个道理，他说这两个在一起，它就瘀在一块儿了，啊。就像咱们这个河，这个土搁水淤泥，啊，那么它要是瘀浅的，它就不去了，古人是这么个看法。那么这个湿热两种东西呀，湿胜热。这个热随湿化，咱们就是这一段所说这个，“寒湿在里，以为不可下也”，这一个咱们也叫做阴黄啊，啊，这个阴黄就属于太阴，他就变成一个，啊，大便不硬，啊，甚至于溏便，那么这个时候你不能下药了。就是用一种这个“以寒湿中求之”，他这个指着，就指着茵陈五苓，就是五苓散加茵陈，啊，这个五苓散

是一个温性利尿药啊，那么加上茵陈呢，就治这一个病。那么如果这个瘀…湿热这两个问题，如果热胜于湿，这个湿随热化，就发现阳明病。就咱们这一…啊，这个茵陈蒿汤就是，这叫做阳黄。阳明嘛，阳明，太阴，阴黄指着太阴。这一个湿随热化，这一个大便秘结，腹满，发黄。那么那个要用泻法，啊，所以 后边这个茵陈蒿汤就是的；那么这一个呢，他指着热随湿化，就是湿胜于热，那么这一个呢，不要吃泻…泻药，是吧？当以寒湿中来求治疗的方法。那么这一段究其实说明什么问题呢？拿着现在来看，这很像说明这个黄疸性肝炎。那么这一个病我们在临床上常遭遇。他在黄没明显发作以前，那就类似伤寒。所以现在我们在临床上也常遇着啊。“我这个肝炎，大夫给我误诊了”，他还净说西医啊，他到急诊，他西医也是一样啊，那个时候看不出肝炎的。好，治了两天发黄了，就是这一个情形。所以这个黄疸的发作，不是一下子，他开始就有。他先得的。也像咱们一般的感冒，无汗，啊。这一个临床上误诊，不光是西医，中医也是一样，都得当时当感冒，但是这个不是错的，这一个没有关系。可是患者常这么说，给我诊错了。那么古人呢，他说这个湿热，这是古人的一种看法，与我们的治疗是一致的，茵陈五苓也好，啊，茵陈蒿汤也好，你像我们这些方剂，全是祛湿祛热的一个办法，他好病。那么这个黄疸是不是就是这个湿热造成的呢？这一个不一定。就这个证候的反应，啊，他是有湿有热。这是他…在他这个病的过程上他是有这种情况，但是他不是这两个是个主要因素。这个现在，这西医他是很会证明了，他总是有这一个，啊，或者是肝胆管，或者是输胆管，它是受了这个阻碍造成的了。那么这是个事实，啊，你不可否… 否认的。所以古人那个看法，他就其这个…啊，这个治疗，根…你像根据我们这个方剂的治疗…所以中医先有规律，他后有理论。他根据这一个，哎，奇怪，用这个茵陈蒿汤啊，或者是茵陈五苓，无一不是祛湿解热，才能够治疗这个病。那么肯定这是湿热造成的。古人是这么样子来看

的。他是先有这个治疗。这治疗，那肯定是古人是一点点试验呐…试验呐，所以中医发展在，啊，几千年前了，那一个时候限制于科学水平，没有科学，可以说，他不是在一个科学的一个理论上，而演绎出来的这么一种治疗的手法，他纯粹是通过临床，所以中医这个东西就是经验医学呀，啊，他经验出来的这套东西。怎么经验呢？还不是拿人试验的嘛，这肯定的，这，这毫无隐晦，是吧？所以中医最先发达是针石嘛。那古时候，在没有铜器以前，就用石头啊，啊，石头磨个尖，一样做针刺吧。所以咱们说是这个针石，啊。他这个人他这样子，有人他就有疾病，有疾病人就得对付疾病，他也想各种法子嘛，是吧？那么这一个也是，你像这一个，啊，所以跟现在的临床上是一样。古人说这个治疗的这个方法，他通过实践，这是一个永远不会错的。我们只是遇着这一种证你就这么治疗，是准能好病。那么至于什么道理？这一个值得，啊，啊…参考着这个近代的生理、病理更能好一些。所以中医的理论要提高，我认为这个地方也值得研究的。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降一字格排版的条文。

在《康平本》有五个缺字符。后边是附注：“于寒湿中求之”。在《宋本》这五个缺字符给删掉了。你绝对不会想到这个地方会是这个样子。

下边我们解读一下：

“伤寒发汗已”，仅仅从字面的意思来看的话，就是太阳表实证发汗以后，症状得解，这个“已”，相当于症状消失。但是这个条文论述的是什么呢？是表证的同时还伴有停饮证这么一种情况。所以这个地方发汗，算是误治。那么“发汗已”，在这儿可以理解成什么？理解成发汗以后。可是这儿我们不排除表证消失，也有这种可能。有可能还有这方面的意思。

在经方理论当中，凡是表证伴有停饮证的，都不能以单纯发汗的方法来治疗，这是一个重要的治疗原则！

我们现在在临床当中也应该时刻要注意，你要认为这个人是表证，凡是你要给他开表证的方剂处理，一定要看看他有没有水证？如果有，那么要在解表方剂的基础上，加合适的祛水的药。如果对这种情况，你仅施以汗法，即使你用的解表剂与他那个表证相吻合，也不能把他的病治好，而且还常会出现新的变证。这条论证的就是这种出现变证的情况。

这种经方治疗原则都是通过一个一个辨证条文体现出来的。而且这个地方论述的是什么？是这一类的出现了黄疸病的情况。

“身目为黄”，就是说的黄疸。后边，他没有进一步的述症，笔锋一转，就开始解释病理：“所以然者，以寒湿在里不解故也，以为不可下也”。这是对“身目为黄”的病理解释。

那么，“以寒湿在里不解故也”，其中的“寒湿”，我们值得分析。“寒湿”应该是指的水饮而言。不能理解为什么呀？不能理解为有“寒证”。为什么这么说呢？整体地看一看，在经方当中，有治疗黄疸功能的方剂，大部分对应的都是“湿热”的病理状态。就是说应该有湿热的病理状态存在，才会形成黄疸。桂枝加黄芪汤和黄芪建中汤，也可以用来治疗黄疸。这两个方剂，总体来看多少也有一点偏温。这儿的“寒湿”应该是咱们常说的寒饮。那么寒饮造成的黄疸又找不到解决的办法，再说临床当中是不是有过这种情况？也就不好说了。

在经方理论当中，凡有停饮的，不能使用下法，这也是一个治疗原则。所以这个地方“以为不可下”。这是符合经方理论原则的。

之后，在《康平本》就是五个缺字符。那么这五个缺字符是什么？很可能，是这个条文的作者根据这种情况，给出的治疗方法。但是内容已经缺失了。胡老读这书啊，读得就是入木三分。他没有见过《康平本》，但是他感觉到这个地方，应该有个应对措施，胡老主张这个地方应该以“茵陈五苓散”之类的方剂来治疗。虽然茵陈五苓散要填到这五个缺字符里边，跟经方通常的论述不能吻合。但是，这确实给

我们指出了对应这类情况的治疗方向。饮重的就是茵陈五苓散；饮轻热重，就是茵陈蒿汤了。

条文最后，注解内容“于寒湿中求之”，实际上是作者对原文那缺失的内容，他想把它完整一下。但是他论述的内容，就是寒湿在里的一个重复。所以没有什么实际意义。

伤寒七八日、身黄如橘子色、小便不利、腹微满者、茵陈蒿主之^①、（260）

注：“茵陈蒿主之”《宋本》作“茵陈蒿汤主之”。

胡希恕：你看这一个他不说是阳明病，都说的伤寒。“伤寒七八日，身黄如橘子色，小便不利，腹微满者，茵陈蒿汤主之。”这个七八天呐，常由表传里的时候。这个书呢，你看这个日子他也不是随便写的，他都根据一般的这个常规。这个表证，四五天、五六天，大概都从表传到半表半里，这是常啊，啊，就说的一般呐。特殊情形啊，又当别论了，是吧？那么到这个六七日、七八天，这就要去表传里，传里的时候是这样子。由少阳病传里，也在七八天的时候，由表传里也在七八天的时候。那么可见这个疾病的这个…这个由表往内传呐，由表先传半表半里的时间最多，也有由表直接传里的，也见有。你像我们在临床上吧，遇着个感冒，啊，没有几天他觉身上无力呀，可是高烧不退，但是他没有太阳病的表证了，觉着身倦无力。啊，就咱们这个《伤寒论》有一个“脉浮细而嗜卧”嘛，懒了，这就是传到半表半里了。所以这个时候他恶心呐，啊，往来寒热呀，不愿意吃东西，一系列的柴胡证都有了。所以咱们用小柴胡汤，这是最…啊，最恰当不过。与这个书上这个说的也是这样。但是又几天了，他由半表半里就进到里了，这个时候大便也干了，舌苔也黄了，啊。那么这个时候你再用小柴胡汤就解决不了这个问题了。他这就是，既刻柴胡证，

他也是半表半里并于里，就是少阳阳明并病了。咱们就要用大柴胡汤了，啊。大柴胡汤是两解，既解少阳，也解阳明之里实了。它加大黄了、芍药、枳实。所以他这个几天，这个…这个日子啊，也不是随便这么写的，啊，这是按照一般常规。那么太阳伤寒七八日的这个期间，常常是由表传里的时候，那么这个时候发黄，身黄，如橘子色。橘子这个是个橙黄色了，是吧？非常鲜艳。他这个热的表现呐，他就表现鲜艳；这个寒的表现，表现这个，啊，黑褐，是吧？所以这个身黄如橘子色，这说明这个湿少热多。“小便不利，腹微满者”，啊，在古人他这么样的看法，是这个黄疸的发生啊，只有热他就是变成一个纯粹阳明病了，要传里的话要有湿，他才能够发黄呢。那么这个情形绝对是小便不利。小便不利，水不得行于外，啊，他就是流于里了。流于里这个热又转为里，所以这个热和这个水两下又结合了，为瘀热在里。腹也微满了，啊，腹微满，一方面是里实，啊，他这个二便不利，啊。小便不利他也是满，但是，这只是微满，不像我们大承气汤，大实大满，不是那样子。可是这一个呢，不纯粹是寒湿的问题了，啊，这个是热较比盛，所以他用茵陈蒿汤。茵陈蒿汤是栀子，啊，大黄、茵陈这三味药组成，头前儿有。一方面去黄，啊，利…利湿，同时呢，它要是用大黄来通便、去湿。那么在这儿也搁个伤寒，啊。所以他开始啊，是伤寒，看不出来这是发黄，啊。那么到七八天了，突然间发现了。这一个…这一个跟上段都是说的我们现在常…在临床上常遇着这个情形，啊，都像一般的这个感冒，啊。以这个太阳伤寒的这一类的病…病证出现。那么这一个，啊，在开始的时候就当一般感冒治了，现在也是的。那么到后来他发黄了。那么古人对这个黄疸呐，他不管是肝炎呐，或者是胆囊里…里面的一些问题呀，他这一个他查不出来，所以中医讲辨证，啊。你…不…现在咱们用这一个…很多的这一个…啊，科学的一种这个…啊，检查的办法了，那古时候还没有的。但是有这种证，这个治疗这是绝对对的。

李冠杰：这个条文在《康平本》是顶格的条文。

条文里边“茵陈蒿主之”，《宋本》是“茵陈蒿汤主之”。显然是《康平本》这个地方缺一个字。

下边我们解读一下：

“伤寒七八日”，就是患太阳表实证已经多日了。但是，并没有得到合理的治疗，而致使这个疾病出现了新的发展变化。这个条文论述的是发展为里热证与水实证同病，并且发生了黄疸的这么一种情况。

“身黄如橘子色”，指的患者发生黄疸的颜色，跟橘子样一般的鲜黄。这是里热炽盛所表现出的所谓的“阳黄”。这儿呢，是里热证与水证同病，而且偏于热的一种反应。也就是热盛于湿。

“小便不利、腹微满”，说明患者同时存在体液代谢不良的情况。临床当中不单单是小便少，他还应该表现为小便短赤。“腹微满”，就是因为小便不利，水停于腹中，患者表现出来的一种症状。

这个条文论述的就是：阳性表证因为没有得到合理的治疗，而发展为阳性里热证并水实证并发黄疸的这么一种情况。

这个条文当中的述症比较简单：“身黄如橘子色、小便不利、腹微满”。但是，这些症状恰恰是在表证的情况下，发展为茵陈蒿汤证的时候，所表现出来的较为典型的症状反应。不是说茵陈蒿汤还治谷疸吗？那个“谷疸”表现是什么呀？表现一吃东西就头晕，那是由里证引起的。

茵陈蒿汤证，在经方里边共有三处专门论述这个方证的。一个是236条，论述的是阳明病合并停饮证，而发生黄疸的这种情况：“但头汗出、身无汗、剂颈而还、小便不利、渴饮水浆”。那么这个条文论述的，是由表证发展过来的。在《金匱要略》还有因为消化道内的病变发展为茵陈蒿汤证的：“寒热不食，食即头眩，心胸不安”。那个呢，是由里证引起的黄疸病所表现出来的比较典型的症状。

我们把有关茵陈蒿汤证的这些条文集合在一块儿，我们对这个方证的理解就会更加全面、深入和准确。而且，还能从中体悟出其他好多东西。一个是茵陈蒿汤证，也不是固定不变的一个症状群，是个动态的；再一个，从病因上看，也不是一条路径引起的。这仅仅是说的是茵陈蒿汤证，而不是黄疸。因为黄疸还有好多其他方证。

你看经方里边这个论述，有时候，东一耙子西一扫帚，好像没有什么规律可言，当你整体解读的时候，就会发现论述的是相当全面。不同的路径发展过来的，会表现不一样，各有侧重。这却恰恰是在临床当中经常要触及的问题，经常要碰到的问题。从这儿，我们体悟到经方论述的精妙。

下边作一个小结：

患伤寒七八天的时间，患者出现身黄如橘子色、小便不利、腹微满的，为茵陈蒿汤主治之证。

伤寒身黄发热者^①、栀子蘖皮汤主之、（261）

注：《宋本》无“者”字。

肥栀子十五个擘 甘草一两炙 黄蘖二两

右三味、以水四升、煮取一升半、去滓、分温再服、

胡希恕：伤寒，身发热，栀子柏皮汤主之。这一个“身热”与这个表证的这个“翕翕发热”，这个热型是不一样的。这个太阳病啊，他“翕翕发热”，感觉这个热呀，笼罩这个人的这个体表，啊，所以他叫“翕翕”，合而不开嘛。这一个“身发热”，这个热都是从里来的，啊。所以阳明病更厉害了他蒸蒸发热，啊。那么这个“身发热”，也就说明不是一般的这个太阳病这个表证这个“翕翕发热”。那么这一类的表证，啊，要是发黄的话，用栀子柏皮汤主之，啊。所以伤寒，啊，身黄发热，他身上有黄而发热，那么这一类的呀，没有这个“腹

微满”，像我们说那个茵陈蒿汤那个内实。也不是像头前儿所说的这个“寒湿在里”，只是热。这一个，这一段文字啊，它是简。那么我们在临床上用这一个方子啊，都是人特别烦躁，啊。如果遇着这一种黄疸，这个人呐，烦躁不安，但是呢，大便不实，就是大便通调，是吧？嗯，里不实，有热而没有寒。这就是用一派苦寒药就行，啊。所以他这个用栀子、黄柏、甘草。这个栀子、黄柏，是这种苦寒解热的药啊……（音频缺如）……黄疸的这个发现也很多，主要他是烦，啊，烦得厉害，所以他以栀子，啊，为主的，另外加上黄柏。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格排版的条文。

条文中“发热者”，《宋本》没有“者”字，只是“发热”，没有原则性的问题。

解读一下：

“伤寒”，在这儿有两层意思：一个是说栀子蘗皮汤证可由表证发展而来；第二，患者仍然表现有表实证的某些症状反应，比如无汗、发热等。

“身黄、发热”，述症非常简单，但这肯定是栀子蘗皮汤证的一个特征性的症状反应。而且看方剂的药物组成：栀子、甘草、黄蘗，一下子就看出来存在“身黄”。这儿强调这个方剂可以去黄，但是“发热”往往想不到，它这儿就给列举了。“身黄”就是黄疸了，“发热”应该是栀子蘗皮汤证的一个典型症状反应，实际临床统计资料也确实如此，因为这个治疗方剂在后呢。所以，这条对于方证中常见的一些症状就略而不论了，没有做举证，但是我们看方应该知道像栀子证、蘗皮证，这些药证都有可能出现的。

这个方证属于比较典型的半表半里虚热证，当然也有一点里热证。所以这儿的“发热”既不同于表证的那种“气不得旁达”的发闷热，也不同于里热证的那种“蒸蒸发热”。这个方证，是在栀子豉汤证的基础上，发生了黄疸病的其中一种情况，所以除了条文论述的“身

黄、发热”之外，还应该有一系列的像栀子类方证的常见症状反应，比如烦躁、虚烦或者说心中懊憹、反复颠倒、不得眠，甚至有点短气都有可能出现，因为这儿有甘草。这些症状不是说都同时出现，是说如果出现的话，也没问题的。在临床统计资料中，这个方证里还有不容易想到的症状，一是“腹痛”出现的几率比较高，再就是里急后重、便脓血这样的热性下痢的症状反应。

这个方证，在临床中实际上就是一种既没有表证，又没有里实证，而且是以“发热、烦躁”等半表半里证为基本特征的一类黄疸病。值得我们注意的是，临床统计资料里有“热性下利”，为拓宽这个方剂的应用范围，为正确地、全面地理解栀子豉汤类方证提供了新的思路：凡是栀子豉汤证，见到寒性下利的可以用栀子干姜汤来治疗；而见到热性下利的可以用栀子蘗皮汤来治疗。

大家再想想第 81 条，那是降二字格排版的条文，“凡用栀子汤，病人旧微溏者，不可与服之”。就是说病人有大便溏泻的情况，不能服栀子豉汤。实际上是根本就没弄懂，那个栀子干姜汤治的就是寒性的下利。有栀子证又有下利的：如果是寒性的就用栀子干姜汤；如果是热性下利的就用栀子蘗皮汤。“病人旧微溏者”完全可以用，第 81 条实际上对后世的影响就很坏了。

做个小结：患伤寒后，表现为身黄、发热的，为栀子蘗皮汤主治之证。

看看方剂。这个方子一共有三味药组成：栀子、甘草、黄蘗。可以看做是栀子甘草汤去掉豆豉加黄蘗。黄蘗是一味寒性的药物，在方剂中有清热、除烦、利湿、去黄、止痢的作用，能够治疗下利主要跟黄蘗有关，栀子本身有一点缓下的作用，加上黄蘗，它就可以治疗有栀子证的热利。

在临床中，这个方剂的方证有几个常见的症状：一个是发热，这跟条文里是完全吻合的，发热出现的几率最高；再就是腹痛、黄疸、

里急后重、便脓血。

舌质：主要是红舌。

舌苔：是以黄腻苔和白滑苔为主。

脉象：数脉、弦脉、缓脉、滑脉。

应用这个方剂治疗的现代病：像黄疸、细菌性痢疾、眼睑搔痒、急性黄疸性肝炎、传染性病毒性肝炎、急性胆囊炎、胆石症、急性胰腺炎、流行性出血热、荨麻疹、皮肤搔痒这类的疾病。

伤寒瘀热在里、身必发黄^①、麻黄连翘赤小豆汤主之、(262)

注：“身必发黄”《宋本》作“身必黄”。

麻黄二两去节 连翘二两连翘根是也 杏仁四十个去皮尖 赤小豆一升 大枣十二枚擘 生梓白皮一升切 生姜二两切 甘草二两炙

右八味、以潦水一斗、先煮麻黄再沸、去上沫、内诸药、煮取三升、去滓、分温三服、（注）半日服尽

胡希恕：“身必黄”，应该有个“发”字，啊，身必黄也行。大概他这底下有个注角啊，大概成无己本这块儿就有个“发黄”，啊，《玉函经》成无己本，全是“身必发黄”，啊。“麻黄连翘赤小豆汤主之”。这一个说是在表，这个就是伤寒，他没说明日子，啊。没说五六日啊，七八日，这就在表证的期间。那么假若他又有瘀热在里的话，虽然有表证他也必发黄，他是这么一个问题，不是传里的问题，他根本里头就有瘀热。那么这一个呢，应该用麻黄连翘赤小豆汤主之。这一个方子啊，啊，解表祛黄。那么祛黄的法子呢？也祛湿祛热，瘀热在里嘛。赤小豆，啊，它祛湿；生梓白皮，啊，连翘，啊，这个全是解热药物；那么麻黄、杏仁，啊，这些药呢，它是解表的药。那么这

一节儿的意思啊，主要就我们在临床上，遇着发黄的病，他是有表证，发烧怕冷，头项强痛这一类的都存在，那这一个他发黄呢，你就…要是无汗用这一个方子，啊。这个方子他麻黄汤基础啊，啊。他麻黄汤去桂枝了，麻黄、杏仁、甘草，啊，他把桂枝去了，他加…搁的姜。姜，啊，啊…这个发汗跟桂枝差不多，这个配伍。但是他没有气上冲，他有恶心。恐怕这一个，啊，啊…有表证，有些恶心，没有上冲的样子，那么这个时候呢，可以用这个…把这个麻黄汤啊，去桂枝，换成生姜，另外，啊，要搁些去黄的药，生梓白皮呀、连翘、赤小豆，啊，这个就是去湿热，以祛黄。它是这么一个方剂。也就是在临床上这个黄疸，在表要发汗，啊；在偏于…在里，我们要根据阳明的这一种治疗，用茵陈蒿汤啊；还有，啊，栀子大黄汤。这个书没有，我们在《金匱要略》里头，那个黄疸篇就有了。那么如果不在表，又不在里，而半表半里，就是小柴胡汤，啊。小柴胡汤呢，啊，配伍茵陈蒿汤或者配伍五苓散，无一不可，不配伍也行。如果小柴胡汤证相当的全，这个也是《金匱要略》上说的，啊，发黄、而呕，啊，再有热，这就是小柴胡汤证，就可以用小柴胡汤就行。当然是，我们要是看他兼里实，那用大柴胡配合茵陈蒿汤就行。如果再遇寒湿，那你就配茵陈五苓。那么这一个表证这是无汗的，要有汗的呢？有汗就用桂枝加黄芪。黄芪这个药啊，也去黄，这个也是《金匱要略》里头的。所以，总而言之，他这个书啊，就是辨证。说什么药去黄，啊，什么方子治疗，在临床上啊，也要根据这个疾病的反应。如果在表，就是我们后头讲这一个，是吧？那么易发汗的，用麻黄连翘赤小豆汤；如果他根本就自汗，可也是表证，他是现桂枝汤证了，就是发热汗出，恶风这一类的情况，那你就用桂枝汤加黄芪。这个黄芪，啊，也去黄。那么如…如果是里证，你就根据这么几个方剂，是吧？茵陈蒿汤，栀子大黄汤，栀子大黄汤就栀子豉汤加大黄。烦的更厉害，我们合用这个栀子柏皮汤。这是我们常见的了。要是半表半里证呢，你就于柴胡汤里来求之，

是吧？大小柴胡汤啊，啊，配伍相当的药物，都可以的。这是我们在临床上常遭遇的。那么到这一个地方啊，我们把这个阳明篇讲完了，啊。

李冠杰：这是一个降一字格排版的条文。

条文当中的“身必发黄”，在《宋本》当中是“身必黄”，没有“发”字。

下面我们解读一下：

“伤寒”，那么这儿指的就是阳性表实证。但是这个方证在病理上，实际上不是单纯的表实证这么一种疾病的类型。

“瘀热在里”，又明确地阐明了这个方证里边还带有里热证。虽然说的是病理，但是说的也明白无误，同时又有里热证。有里热证，就有里热证相应的一些证候反应。

“身必发黄”这个“必”字，也应该当作：如果、假设、假如这一类的意思来理解。这个条文述症也非常简略，要想全面地认识这个方证，还要结合后边的方剂和临床的统计资料。

在病理上，这个方证不仅仅是表实证合并里热证，同时还有停饮证，也就是说水实证这种病理夹杂在里面。

临床统计资料显示，这个方证的主要症状反应，有下面这么几项：发热、尿短赤、水肿、恶寒、发黄、食少、头身痛，有这些比较典型的症状反应。大家看一看，发热、恶寒、身疼痛，是表证的症状反应；尿短赤、发黄、发热，这是里热证的反应；水肿、发黄、食少，又是水实证的一些症状反应。这里边虽有交错，但是这三种病理却是明白无误的从症状反应里边都能体现出来。

我们做个小结：伤寒的同时又有瘀热在里，如果身发黄的，为麻黄连轺赤小豆汤主治之证。

下边看看这个方剂：

这个方剂是个常用的方子，由八味药物组成：麻黄、连轺、杏仁、

赤小豆、大枣、生梓白皮、生姜、甘草。方剂后注解有“以潦水一斗”，这实际就是指的地上的流水，咱们现在也没有人去讲究这个了，一般自来水就行了。这个方剂主要的药物我们都很熟悉：麻黄、杏仁、甘草、生姜、大枣，我们前边都不止一次的介绍过了。这几味药，大家看像大青龙汤、越婢汤、麻杏石甘汤，甚至包括麻黄汤，这些汤剂的主要药物，大致都是以这些药为主的。所以说这个方剂，它治疗表证是显而易见的，这个没有什么疑问。

这个方剂跟我刚才列举的几个方子相比较，去掉了石膏，但是它又有“瘀热在里”，它实际上是用连翘、生梓白皮和赤小豆取代了，把石膏给取代了。说明当在表证的情况下，出现黄疸的时候，而且同时又有里热，这种情况石膏是治不了的，不是石膏的治疗范畴，所以说就把石膏给去掉了。换句话说，这不是石膏证。连翘，在书中有这样的解释，就说是连翘的根。但是实际这个连翘是很少见的，你买都买不到。我给安国那边打了几次招呼了，都不知道这是什么药，找不到。实际临床当中，我一直都是用连翘代替，后世基本上都是用连翘代用。虽然《神农本草经》中这两个药物的药性，它有一定的差别，但是实际临床应用当中，也没有说因为这个药的变动，影响这个方剂的疗效。只要是方证相应，依然是疗效很好。在寒热属性上，连翘根明确的资料上都说它是寒性的，连翘是属于平性的。但是从实际临床应用，我想在这方面凡是谈到药，大家都应该有一个自己的认识，你应该去从方剂当中去体悟这个药。

大家可能通过我跟大家介绍药，都能感觉出来，我从来不跟大家介绍这个药是什么味的，苦味、甜味，但是我必会给大家交代清楚这一味药的寒热属性，哪怕它是平性的，我也给你说没有明显的寒热倾向，因为在临床当中这一点很重要。大家去看附子的应用：附子是一个热药，在真正属于寒性的病里边它的用量就比较大；但是在热性病里边，又不得不用它的时候，它的用量非常小。像薏苡附子败酱散、

肾气丸里边，附子的用量都很小。因为它的寒热属性跟病症不太相应，但是你又没有别的药物，能够起到这种振兴机能的作用，那怎么办呢？少用。这很重要！你在临床当中用久了以后，逐渐地，经方慢慢的就变了，经方的方剂之间的比例不是不能动，关键是动的依据是什么？你有没有动这种比例的相应的知识，这很重要！

就拿这个连翘来说，连翘资料上都说它是平性的，但是我们从实际临床应用看，包括后世时方的应用，像银翘散之类的，对应的都是一些偏于热的证，所以说这一味药实际也应该是偏寒性的，在这个方剂中，它有清热、祛湿、退黄的作用。

生梓白皮，它有一个特殊的情况，书中的剂量单位为升，但是这个东西又是一个比一般的那种树皮稍薄一点、稍微硬一点的样子，它既是一个树皮，用升就不太好剂量。之所以用升，可能当时古人考虑到患者能够采到鲜品，因鲜品跟干品在重量上会有差别的，所以它没用斤两，而是用了升。用升的话想必他当时也是不会把它粉碎了的，它要求是切，所以说咱们现在的饮片切了以后也有跟它差不多，我做测试，一升干燥的生梓白皮，大约是 60 克左右，也就说相当于 4 两，这样在方剂当中你就比较好跟别的去对比了。这一味药物是一味寒性的药物，它也有清热、祛湿和退黄的作用，同时这个药物还有治疗像一些疮痒、疥疮、皮肤瘙痒这一类病的功能。所以这个方剂也常常用来治疗一些皮肤病，就跟这个药有很大的关系，因为它的用量也比较大。

赤小豆是一味平性的药，寒热属性不是很明显，但是它有祛湿、下水、和血、排脓、消肿、解毒和退黄的这种作用。

从临床统计资料看，它表现的症状反应有下边几种：发热、尿短赤、水肿、恶寒、发黄、食少、头身痛、腹胀、咳嗽、呕恶（就是说呕吐、恶心）、心烦，就表现为这一类的症状。

舌质：红舌比较多，淡红舌比较少一点，主要看都是舌质偏红。

舌苔：黄腻苔、薄黄苔、薄白苔、腻苔，这一类的。

脉象：数脉、浮脉、弦脉、滑脉。

从现代应用看，有应用这个方剂的机会的现代病：像黄疸型肝炎、急性胆囊炎、急性肾盂肾炎、肾小球肾炎、小儿肾炎、哮喘、荨麻疹、过敏性皮肤病、鼻炎、结膜炎、过敏性紫癜合并肾炎、原因不明的眼睑或者说面部血管神经性水肿（这跟表证和停水都有关系的）。

阳明病小结

胡希恕：这个八纲分析呢，就是里阳证。就是阳证在里，啊，就病位上来说它是在里。那么什么叫做阳明病呢？它不是一个什么特殊的个别的病。就像咱们说是，啊，肝炎呐、肾炎呐，它是个别的病。这个它跟太阳病一样。在这个书，古人这个…啊，这个病名啊，这都是一般的证。什么病都可以得阳明病，阳明病不是单独的这么一种病，啊。那么它有特征，啊。什么特征呢？在这个书里头啊，他是匀两段说的。所以“阳明 之为病，胃家实是也”，啊，这是就腹证。日本，嘿！老讲腹诊了，是吧？那么这个就是病实于胃肠之里，拿手摁呐，真能够有抵抗，甚至于压痛，啊，就是摁着心下这一个部位，这是就腹证上说的。那么有的阳明病只热而不实，那就…这个腹诊就没用了。他光热，所以呀，在阳明篇里头，就咱们这一章，他又提出个阳明病的外证，那么他没有胃家实，拿胃家实怎么来…啊…来辨阳明病啊？那么这个外证是什么呢？身热，汗出，不恶寒，但恶热。这是这个外证。那么换言之，无论什么病，有胃家实，或者有身热，汗出不恶寒但恶热，都叫做阳明病。无论什么病。所以这两个，啊，一个他的腹证胃家实，一个他的外证身热，汗出不恶寒，反恶热，这是阳明病的特征。我们可以这么来理解它，啊。那么凡是阳明病就得具备这个条件。我们在临床上呢？也就是拿着这一个作判断阳明病的标准。这个阳明病怎么来的，这个书啊，开始就…就说了。他说有太阳…太阳病不解，而转属阳明者，叫做太阳阳明。那头前儿有，啊，他还举例子，如脾约是也嘛。在太阳病，啊，由于我们治疗的这个不当，用一种这个，啊，应该发汗、吃泻药，使之热陷于里，也能够转变为阳明病。就即便依法发汗，那么如果这个病啊，它是相当的重，就是我们依法治疗，也不一定在太阳病这个阶段就把病治好的。这在临床上也是，啊，不可忽视的，尤其这个真正伤寒。所以伤寒为大病啊，啊。它这个好的时候啊，全在这一个少阳的末期、阳明病初期，就在这一个大柴胡汤、白虎汤这个阶段，甚至于这个，啊，调胃承气汤这个阶

段就可以好的。但是它在表，在这个太阳病这个阶段呐，常常都不好，啊。就你治之得当，不过是杀一杀这个…啊，病势的这个，啊，猛…来…这个来势而已，能够减轻，啊，使之转里或半表半里，不那么猛暴，啊，这是肯定的。你要是治之得当啊，是能达到这一个目的。一般的轻病呢？那表证的时候就可以好。咱们一般得感冒，是吧？轻微的感冒，你喝点姜汤也好，啊。就弄点姜水你喝一喝，出点汗，吃点茶叶出点汗都可以好的，是吧？但是他都是轻病。真正的这个重病啊，那不是随便那么吃药能好的，就得按照规矩。该用麻黄汤的非用麻黄汤不可，你用桂枝汤就不行，该用桂枝汤的用麻黄汤更不行，是吧？那就得…啊。所以他这一个书呀，这规律非常的严呐！啊，他辨证那严得很。他不但要辨六经、八纲，而最后他要辨到方证，方证就是咱们讲这一套，啊，就是一个方剂有它一个适应证，它所适应的证。不这样子啊，你在这个临床上啊，常常的达不到这个疗效。一般轻证那没问题，你错了都不要紧，啊。他这病根本就是不要紧嘛。所以这个阳明病，由太阳病传来的，就像我说这几种原因吧。也有些误治，有的在太阳病的这一个阶段发汗，啊，发汗也许太过，那么丧失水分太多，内里头有燥结；也有重病，在太阳病虽然，啊，治疗得正当，但是它在这个阶段好不了，它也是要传到这个…传里或传半表半里的。咱们讲这个里了，咱们就说传里吧。那么这一个呢，如果传里之后了，阳明病已发生，太阳病还存在，这叫做太阳阳明并病了，就这一个书所说的“太阳阳明是也”，啊；那么少阳阳明呢？也是一样的。这个少阳病，啊，这个病已经不是表证了，传入少阳而发生少阳病，这个少阳病，啊，也有由于这个误治的，使之邪更陷于里，而发生阳明病的，也有的，啊，你像利小便就是的。他丧失津液太多了，啊，它也使着大便干。少阳病啊，不可吐下或发汗，啊，只能用和解的法子。如果我们用发汗或者吐下，那么咱们讲到少阳病就有了，啊，“吐下则悸而惊”嘛，啊。这一个，一虚其里，所以中医讲这一个“邪之所

凑，其气必虚”呀。本来胃肠它不虚，你吃吐药、吃泻药，就虚其胃肠，那么外边这个邪热呀，趁着这个胃虚，就往里头去，那也发生阳明病。那么还像我方才说这个表证那个样子，也有这个病重的，在少阳病啊，没治错，也有传为阳明的。那么如果转属阳明了，就是少阳病还没解，阳明病已发生，这一个阶段，就叫少阳阳明并病。那么这个书上所说这个“少阳阳明者是也”，啊，就是我方才所说的这个。那么他有假设说无论从太阳转属阳明或者从少阳转属阳明，而太阳少阳没有了，只是阳明证了，什么？就是胃家实，就叫正阳阳明。所以他把这个阳明啊，分成这么三个，他特意说个问答。没有少阳、太阳的痕迹了，它整个没有了，只是阳明病了，那阳明病的那个最终啊还是胃家实，是吧，那么就是胃家实叫正阳阳明。那么这一个就这个阳明的，啊，发生，而来分这个阳明有太阳阳明、有少阳阳明、有正阳阳明，啊，这么一种说法而已，这一个不是个重要。我们方才说那个重要，阳明病得有它特征。那么另外阳明病啊，他讲治则了。阳明病在原则上得怎么治疗呢？那么这个书上他也提出来了，啊。如果里实“当攻”，就是当下呀，啊；如果里热而不实，就像我们方才说那个，只有外证，啊，没有胃家实，这个不能吃泻药啊，这个得清热，他这个白虎汤，啊，这就是清热之剂了。那么这里头啊，我们要回头想一想，啊，凡是热结于里需攻的都是阳明病啊。咱们讲太阳病，啊，那里头，啊，有很多，啊。结胸证，是不是阳明病啊？是阳明病。所以现在把它搁到太阳里是不对的，啊。他这个明明说“热结于里”嘛，水结胸胁，是吧？他这热结于里，他就是阳明病嘛，所以它也得攻，而且他所用那个方剂呀，啊，那比这大承气汤都猛烈。不过他是…得攻水，一方面攻里实，一方面攻水。所以这一个…攻下这一种方剂，在这个地方可以…我们可以也看出来了，配伍什么它起什么作用。你像咱们这个承气汤这几种，他都想法去食、水、积滞，啊，所以它配伍是厚朴、枳实。厚朴、枳实这个药啊，咱们一般健胃药常用的，啊。

你像平胃散，不还搁…也是搁半夏厚朴嘛。他里头有东西，有这个存食，他觉得有胀满。所以咱们只是说它行气消胀，其实由于食…食积的方面最多。所以配合厚朴枳实，啊，就去宿食，燥屎等等的。你要配合这一个甘遂、大戟、芫花这一类药呢，它就是下水。所以也用…也用大黄嘛。你要配合血分药，啊，你像桃仁、丹皮呀，它就下血，去瘀。所以我们在太阳篇里讲了很多是阳明病。结胸证属阳明，桃仁承气汤证也属阳明，抵当汤证更不用说，全是。他不过在这阳明病里头啊，他有，啊，有些其它的关系，有兼发瘀血证的；也有，啊，这个水湿结于胸胁的这种结胸证；那么再有，我们再好好想一想，这个泻心汤，就这…三黄泻心汤，大黄黄连泻心汤，是不是里证？也是里证。不过它下火。我们方才说了里热当清。但是这一种火在那个地儿，由于郁到那个地儿它不去，这在这个《神农本草》都说是“热气”呀，是吧？他那一个，你也得往下攻。所以这个大黄你要配合这个苦寒药，它就能下火。你像咱们现在用这个，啊，黄连解毒什么都是这个东西呀，啊。黄…啊，黄芩、黄连、栀子加上大黄，那下火相当有力量。这个火，啊，它郁结这个心下部位它就成了痞，这是指着这个痞，不是咱们说那个，啊，胃虚衰那个痞，不是那一个。这一个也由于我们，误治，造成的多，在表证的时候，吃泻药，啊。他没结实，但是这个热，可陷于这个地方了，心下部位。这也是属于…应该属于阳明，它是下火的一种手段。那么还有我们头前儿讲过这个瓜蒂散，也是里证。这个里证啊，我们现在可以这么体会。为什么发生里证啊？他这个人身上这个疾…这个…这个人体呀，这东西也是妙不可言呐。它也…它是老想…啊，人有了疾病了，它就要对于疾病抗御，啊。你像《内经》上就有啊，在这个表证的时候，他说“夫邪气交争于骨肉”。这就是表证的阶段。表证阶段呐，就是邪和人的这个，啊，精气，在这个皮肉，啊，骨肉之间在这儿打仗的。所以咱们在这个，啊，中医老讲“正邪纷争”就这一个问题。咱们讲那一个柴胡证，你看见，那讲得很好

啊。那么在这儿打仗，他不是这个…人这个生理呀，它不是万能啊，它有这么一种反应，它打算由体表来解除疾病，事实上它解除不了，限于自然良能。怎么办呢？它又是在这一块儿，啊，就像打仗似的，他打不胜了，哎，它就要想法往里头转移，它就是变更这个御病的这种机制吧，它就发生这个少阳病。你看看咱们那个，啊，头前儿那个柴胡剂讲的非常好啊“血弱气尽，腠理开”呀，表证的时候啊，它这个血气尽量往这个体表上来。它干什么呢？攻邪呀。它打算由汗而解。那么这一个它达不到了，达不到了，啊，这人的体力也有所不支了，它就是…它就往里头，啊，就给撤外边而自卫于内，那就是半表半里这个部位了，就是胸腹腔间了。那么这个时候呢，你看这个书上说得真好“血弱气尽，腠理开”，那不是虚呀，他是把外边的这个，啊，气血往里头撤。干什么？他是防卫里头。所以邪气因入，啊，与正相搏结于胁下，这一段解释得相当好啊，解释柴胡剂呀。这它，还是要打…要是御敌，不过它换个方向。那么我们现在呢，要是结合生理来看呢，他就要利用这个，人的很多的脏…脏器功能啊，来解除疾病嘛。就是由呼吸道啊、由泌尿系呀各个方面吧。他这个半表半里这个部位啊，就是人身上这些脏腑是聚集之地，都在那个地方。他利用这些腑脏来解除，所以这就发生这个少阳病，这么一种病理阶段。那么这一个也不行了，那么最后了，就想利用消化道来解除疾病。消化道有两个方面的，一个吐出，一个泻下。所以把这个病邪呀，尽量包围到胃肠里头去。这是人的妙计呀，所以他有个里。所以我们疾病万变呢，你看，他反应到人体上就那么三个部位，不是表就是里，再不就是半表半里。所以这一个，这个疾病才有一定的规律，要不他没有啊，为什么你说这个事儿？就是人体的解除疾病啊，只这么三个方向，你可知道！这个汗腺排出疾病，啊，这是在人身上说，这是一个外围作…作战了，这是最…最良之道啊，啊，在体表上打，是吧？那与人妨碍不大，所以这个表证死证很少啊，啊；那么再打不了，它往里头

退，啊，退到半表半里，借助…啊，诸多脏器的协力，而来消除疾病，他是这个样子；这也不行了，就得用消化道了，啊，涌吐、泻下，来驱除疾病。但是都限于人的自然良能。达不到，达不到怎么办呢？所以中医呀，讲这个“顺势利导”啊。顺势就顺这个病势。所以这在临床上这需要一个深入观察。啊，这个病…你看那个…那个，尤其那一个瓜蒂散，那写的最好。他说这个心里头老愠愠欲吐而不能吐，说明这个病理的这个机制啊，它也打算吐出啊，你可知道？甚至于…啊，气上冲咽…冲咽，而不得息，他光有这种反应，他吐不出来，所以这个时候你一吐，准好。所以这个书上这个说什么，啊，伤寒呕多者不可下。这个病要往上走，你顺其势导之而出就完了嘛，是吧？那么这个阳明病就是这样子，他虽然把这个病，整个集中到胃肠里头，反倒发生这个不大便了。那你怎么办呢？大便不就好了嘛。所以它就是…我认为是涌吐的方剂或者泻下的方剂，这都是去里实的手段。它在上边，啊，你根据这个病的这个趋势了，欲哕者哕之，啊。那么不愿意往上哕，你但要往上吐，这也不行的，是吧？这是我们说这个，总结这个…这个阳明病，啊。所以呀，这个疾病万变呐，因为人身上有这么一种御病的机制，所以这个病啊，它不出于表、里、半表半里。人的这个身体是万人皆同啊，是吧？不是一个人一个样。所以他反应出来的病呢，就有一定的方位。咱这个六经所以有用，就在这儿。不是说是伤寒病有六经，万病里都有六经啊。它六经就是表里，半表半里三个病位，它反应出来两类病情，一个太过的阳，一个不及的阴。所以表有阴阳，里有阴阳，半表半里也有阴阳。就这么六个基本类型，这是不会变的。那么古人他发现这个呢，也是经过千难万困呐，是吧，那个时候他…啊。咱们看他书是 较比容易了，那古人发现呢，且不容易了。这一个现在咱们临床上是不是这个？也的确是一点不错，啊。不过在这个三阴篇这个病啊，发作的比较少。那都是在这个，啊，病比较严重才有这一种情况。那么三阳篇这是大家都常看的，也就因为

这一个，对于三阴篇的这个解释，啊，大家就随便说了，是吧？因为他找不到一个，啊，很好的一个现实的一个说明嘛，三阴……三阴篇。三阳篇不是的，这个我们在临床上天天看着这个东西。这是说明这个阳明病的这个治则方面，我们…啊，整个的把它扩展看一看，可能是这些…这样子，啊。那么这个治则是个原则的东西，那么他这个书怎么治病呢？还应往前分析，就是辨到这个具体的方证上，所以他这个书讲辨脉、辨证并治，不是让你辨到六经就完了，你看看就这个泻下，他三个承气汤，还有一个麻子仁丸。用错了就是不行，是吧？他这个非常的细。在这个白虎汤里头呢，有白虎汤，有白虎加人参汤……（音频缺如）……不来用它那也属于误人的。这个都是大夫的责任了。所以这一个书啊，都与大承气汤这是反复来…来论。所以，既要有潮热，还要有燥屎，才可用大承气汤。那么大承气汤，不要误会它，他就是燥屎就用大承气汤，那不对的。他是以此这个燥屎，就这大便硬啊，他作它一个用大承气汤一个火候、标准，它可不为大便硬而设。这一点我们必须要把这个搞清楚。所以这个书也好啊，他特意对于大便硬提出很多来。你看嘛，由于汗出多而大便硬，没有发热的情形，这一个泻不得。所以他头前儿蜜煎导那不就有，提那个问题了嘛，啊。那么，就是厉害了，这个人呐，素日这个津液就是亏，尤其老人，老人得这个习惯性便秘最多了。他津液虚，这一个便秘你也攻不得，阳绝于里嘛，他这个…啊，他这个书上说的这个。这个顶大了不起能用个麻仁滋脾。麻子仁丸呐，就是麻仁滋脾这个方子。这一个，这里也是大便硬啊，这不是用大承气汤的一个目的。大承气汤既要大热大实，啊，可是那个实到什么程度呢？大便硬那个程度。不到大便硬那个程度，你不能用大承气汤。他是这么个东西，所以这一个你非把它搞清楚。那么另外大承气汤啊，也不要老守这个常规，所以他有个三个急下症嘛，啊。“目中不了了，睛不和”这是一个，啊；“发热，汗出多”，这也了不得，马上这个津液脱尽，啊，那一个也得赶紧急下，

这一阵儿你也别…别管他这个…啊，大便硬不硬了，是吧？还有一个，那么发汗后，当时就腹满痛，又满又痛，这个病都…病的来势凶猛啊。这得记，这个东西得记呀，你不然的话，你在临床上你，你掌握不好。所以这个为医之道啊，既要谨慎，啊，那么又要当机放胆。你才能治病呢，不然的话不行的。那得怎么办呢？就是对于这个…古人这个东西他也实践嘛，就对这个东西你得掌握。所以这一个，不是在原则上，就是立法就能会治病，那不行的。所以这个地方啊，咱们对这个研究完了，是吧？对这个阳明篇，这个必须要知道。那么再就这个，三个承气汤它是有些不同。这个调胃承气汤，你搁个“调胃”，是吧。那么这胃不和有热，这个大黄芒硝这两味药啊，这个芒硝这个药它是一个寒性泻下剂，啊。这个调胃承气汤以大便干，以热为主的。这个小承气汤啊，也是大便干，它以满为主。它厚朴、枳实嘛，它还有个 大黄。这个调胃承气汤呢，没有厚朴、枳实。但是它不… 这个小承气汤这个热，去热的力量差的多，没有调胃承气汤去…去热的力量大。这个大承气汤啊，既能有芒硝，而祛…啊，所以这个发潮热嘛，啊，它去热；又有厚朴、枳实，啊，而祛满。所以，他这个大承气汤所以叫个“大”，也就这么个原因。能祛大热，能祛大满，是吧？它这个量也重啊，啊，厚朴、枳实的量也重。同时它也大泻下，所以这个药，啊，特别猛峻。那么这一个，啊。这里头啊，你像茵陈蒿汤，不是说是发黄都属于阳明病，可攻的。啊，你像他说的寒湿，啊，以为不可下也，那不属于阳明病，是吧？那么茵陈蒿汤呢？就是属于阳明病。那么不在这一个里头，你像那个…啊，在这个《医宗金鉴》、《金匱要略》，那么他这个栀子大黄汤，那也属于阳明病。所以那…啊，那一个都是现出阳明证候的一种发黄，那么根据阳明病的法则治疗就可以，啊。这一个…这个阳明病啊，还有什么可以总结的呢？治则…再就有呀，不是说是他这个书，在阳明篇的方剂都治阳明病，他不是的。那么这一个方剂，啊，桂枝汤，麻黄汤都有啊，你说这也治阳明的吗？

它不是。这个阳明病啊，也有它治疗上有一定的方法。有表证在的话，虽有阳明病不可攻之，必须先解表，啊。所以他这个桂枝汤、麻黄汤搁这里头，全是表不解，也都属于并病之类的，啊，先解表。那么其它的方剂也有啊，你像这个，啊，猪苓汤，它是利小便的，他这个他是比较。比方阳明病里热他渴，这个猪苓汤也渴，啊，他是不是这个渴与那一个渴他在这儿作个比较。阳明病的渴与这个猪苓汤的渴是不一样的。他凡是他这个书啊，全是的。大阳篇里头的方剂，不全是属于太阳病。这个阳明篇里的这些方剂呢，也很多不属于阳明病。尤其这里四逆汤，它是一个“表热里寒”呐，这是错。那么王叔和那个时候啊，他编辑这个书啊，啊，他也兴他的看法儿不一样，啊，他就把这一段呐，应该属于太阴病里头的，他搁到这儿了，这是错的。可这个错不要紧，也影响注家在这里作文章，啊。哈，啊…说这是胃寒，也属于阳明，那就错了，嘿，嘿！ 那就不对了。你看他这个，我们将其讲太阴篇就知道了。 啊…，咱们今天就讲到这儿吧。是吧，回去，同志们再…再自己看一看，我说得这个也不…也不太够全面。（音频 030 完）

李冠杰：从内容上看，阳明篇论述了阳明病的定义、阳明病的基本类型和阳明病主要的方与证，同时还用了相当的篇幅论述了阳明病当中的一些特殊情况，特别是大承气汤证的一些比较特殊的情况和阳明病治疗过程当中容易出现的一些变证及其处理的方法。另外，还在最后涉及到了一点就是阳明病与其他类型的疾病同病的情况。

从阳明病的定义上看，经方理论当中的阳明病，在病理上是指的疾病类型属于里证，而疾病的性质属于阳性的热证和实证的这么一类疾病，就是阳性里实热证的这种病理状态。因为这一类的疾病它是个很宽泛的范畴，经方理论在论述上采取了一种避繁就简的方法，将阳明病定义为“胃家实是也”。在经方理论里边，只有阳明病的定义是用病理来论述的，其他类型的疾病都是以症状反应来论述的。虽然

说我们用今天的论述的规范来衡量的话，就这么一个“胃家实”，就未免太过于笼统简略了。但是在当时的历史条件下，我们也可以把它看做是一个高度的概括性的总结。

从我们知道自有经方这本书，一直到我们学习的今天，绝大部分人始终脱离不了一个问题，病位的问题。拿阳明病来说，阳明病特别是里实热证，这一类的疾病以消化道内的病变出现的几率最高，这些症状好多都是消化道内的病变表现出来的，就连顶格条文的作者也把它归纳为“胃家实”。但是，事实上阳明病的方证里边有相当一部分症状，不是发生在消化道内的。比如白虎汤证的“发热”，这跟消化道一点关系都没有。可以这么说，它有时也可以涉及消化道，大部分情况下跟消化道一点关系都没有，实际上它也是阳明病。而且有的时候，在消化道内找不到病变，或者说主要的病变位置不在消化道内，但是人整体处在一个阳性里实热证的状态下，实际上它也是阳明病。但是在经方理论的学习过程当中，大部分人始终摆脱不了病位这个可以说是一个桎梏，老是摆脱不了这种限制，一说到“里证”，那肯定就是消化道内，或者说甚至是以消化道内的症状反应为主，总是把目光集中在这个地方。

实际上经方划分的是症状，是以方证为基础的。关于这一点，我们在下篇少阳病篇里边比这个还要典型，咱们在那儿再做一点讨论。这里就让大家时刻记住这个事儿。这个经方理论里边的病位：可以说都是抽象的，不是具体的病位。

阳明篇把它的基本类型阐述得非常清晰，根据病理属性的不同，大至可以分为两大类：一类，是以承气汤类方证为代表的里实热证；另一类，是以白虎汤类方证为代表的里热证。阳明病的本质，已经跟大家在解释具体条文的时候有过解释，但是不是说特别的规范。

阳明病的本质就是人体在不断适应外界环境的过程当中，由于自身或者人为的因素，而导致自身的调节能力无法维持正常的生理活

动，在这种情况下，发生了人体机能偏于亢奋的这么一种疾病，或者叫做一种病理状态。由于这种疾病，人体患病以后表现出来的，也是相当复杂的，陷于虚证的，有蜜煎导这一类的方证，有麻子仁丸这一类的方证，瘀血证也论述了抵当汤证等等。所有这些出现在阳明篇，我们都应该把它看作是举例说明。特别是抵当汤的论述，包括猪苓汤，在太阳病里边已有论述，放在这儿，就是跟大家举一个例子。阳明病有它的基本类型，它还会和其它的疾病，有同时发病的情况，而且这儿举的只是些例子。现什么样的方证，他就是什么样的病理状态。

通过阳明篇我们还应该明确，这个在太阳病篇里早就有所论述了，阳明病的治疗原则就是“热者清之，实者泻之”。实际上，我们学习阳明篇具体的内容，像上边这些不是说特别的重要，而是站在一个通盘全面地来看的这种角度，我们做了这么一个简略的总结。其中更为重要的，我们应该体悟到的是经方理论的论述特点。

阳明篇作为经方理论，就是六类疾病的第二篇，除了太阳篇之外，它在论述内容上是比较完整的，也比较全面。它不如太阳病论述的那么全面，但是相对其它篇章来说，它也还算是比较全面的。这一篇起到一个在太阳篇和其它篇章之间一个过渡的作用。

太阳篇论述了那么多的疾病类型，你学了阳明病之后，你回头再审视太阳篇，你会发现：太阳篇里边什么病都有，目的是想用那些东西来阐述经方理论的理论基础，从太阳篇里边就把人体的生理、病理，包括医理、疾病的变化规律等等，所有的经方理论的基础，都在里边以方证的形式表述出来了。所以说，它里边集中了几乎所有类型的疾病，它都有一些典型的方证作为例子。

但是阳明篇里边，实际上围绕着阳明病，又展开了另一轮的讨论。这一轮的讨论，明显的跟太阳篇的不一样了，它是围绕着阳明病开始的。它论述的重点不是基本的生理、疾病变化规律等等，基础方面的东西就不是这一章论述的重点了。

这一章论述的重点，它是做了一个很重要的示范！它论述了一些很基本的问题，就是不同类型疾病之间有一些内在联系，它还有一些互相之间的穿插的一些合并病的，在这一篇里边都有论述，而且阳明病在治疗过程当中还会有一些变证。到后边篇章里边，这一些论述就没有了，特别是少阳篇，少阳篇里边论的是什么呢？给你说明这已经是坏病了，没有柴胡证了，就是坏病了。坏病怎么办呢？前边有，方证相应，你去套方证就行了。所以说阳明篇在这有一个很重要的作用，就是示范作用。

经方理论在论述上有一个最显著的特点就是：尽可能避免重复论述。比如阳明篇中论述的很多方证，在太阳病里边也有，你去对照这两个条文，比如白虎汤证，太阳篇里边有，阳明篇里边也有，它们是一个互补的关系、绝无重复。这种论述方式，给解读造成了一定困难。我们今天要论述的话，绝对不会是这样一种论述。但是在当时的历史背景下，这还是一种比较高水平的写作方式，因为它可以省很多文字。所以说我们要学好经方理论，你就得全面地、整体地来理解。不要说我碰到阳明病方面的一些问题了，我打开阳明篇去看吧，那不行。很多东西阳明篇里边是没有的，因为在别的地方论述了。但是在这个地方给你指明了方向，阳明病是哪一类型的，哪一种类型的属于阳明病，哪一种类型的是阳明病和其他类型的疾病同病的，你再看别的方证的时候你就知道了。凡是有里实热证这种病理因素的，都有阳明病的属性，可能它与别的病同病，那也没关系。

辨少阳病^①

注：《宋本》作“辨少阳病脉证并治第九”。

少阳之为病、口苦咽干目眩也、（263）

胡希恕：今天咱们研究这个少阳病。“少阳之为病，口苦、咽干、目眩也。”这个少阳病啊，就是半表半里的一种阳性证。那么这个阳热在这个半表半里这个部位。半表半里就所谓这个胸腹腔间呐。它不…不能够入里，也不能出表。那么这个热在…热邪在这一个地方啊，它只能够循着孔道往上…往上来。所以“口苦、咽干”，啊，都是孔窍地方，发生这种热象。“口苦”，啊，这个少阳病口苦最准确不过。所以在临床上，这个人口苦啊，那肯定这是柴胡剂，啊，柴胡证。“咽干”，啊，内有热，咽也干，啊，这个热往上亢，啊。“目眩”呐就是头眩晕。那么也就是说，在这个半表半里这…这个部位呀，要充斥热邪呀，这个“口苦、咽干、目眩”，啊，这一系列的问题，他是一个必然的反应，啊。所以拿它作为少阳病的一个特征，啊，那是非常…比较正确的。但是也有不足的地方，我们过后讨论的时候再研究，啊。那么这一段的意思也就这样子。说少阳病啊，啊，不是什么特殊的病。只要是在临床上遇着“口苦、咽干、目眩”这一系列证候，我们就肯定他是少阳病证。这就是…啊，对辨少阳病的一个特征了。

李冠杰：这个条文在《康平本》是顶格的条文。

下面解读一下：

少阳病在经方理论当中，是三阳病当中一个重要的疾病类型。

那么这个疾病类型，无论在病性和治疗方法上，或者包括常见的病变部位上，都跟另外的两类阳性疾病，就是表证和里证，都有质的区别。所以，称作是“少阳病”，或者叫“半表半里证”。

这个条文，就是这一类疾病的提纲。对于经方理论的辨证体系的认识，历来就没有一个统一的标准。因为对这个理解的角度和理论体

系的不同，每个人都有自己的一套理论体系。特别是中医里面，这方面就比较杂乱一些，这种倾向比较严重。自己的知识结构不同，看问题的角度不同，理解也不同。但是，所有解释经方理论的注家们，都忽视了一个最基本的问题。是什么？就是说在经方医学当中，疾病的概念是什么？因为这个问题太菜了，就是说太基础了，很少有人去仔细地琢磨它。要是真问到这个问题，还有很多人回答不了。

经方医学当中的疾病，指的是什么？是按什么划分的？咱们以少阳病为例。明明这个少阳病，它的发病部位大部分集中在消化道以外、体表以内。为什么要用一个“少阳”来命名呢？再进一步说，少阳病到底是一种什么样的病呢？要如果从这个角度入手，这个问题反而变得简单了。所谓的少阳病，实际上就是指的一大堆既不是表证，又不是里证的阳性方证，它就是一堆方证。不是一个方证，是一堆方证。每一个具体方证，才是经方医学中的疾病。这是经方医学与其他任何医学之间的一个本质的区别。

我们现在说的可能比较抽象一些。以一个具体的疾病做例子，大家就比较容易理解了。比如肝炎，这是一个现代的疾病病名。现代医学认为：肝炎是人体内部相应的致病因子，也就是造成肝炎的这种致病因子，超出了正常值的范围。所以治疗上就要采取相应的办法来控制它，想办法控制到正常范围之内去。

传统医学呢，认为这一类的疾病，是肝脏发生了或者是阴虚、或者是阳亢等一类性质的病变。那么治疗呢，治疗就要用入肝经的，而且适合寒热虚实的这一类药物或者是方剂来治疗。

这些医学的实质：都是以病变的部位和病变的性质来界定疾病的，这毫无问题。并且从这个认识的角度，又来以此理论做为寻求治疗的方法。这就是经方以外几乎所有医学的一个本质性的东西，都相同了。虽然叫法不一样，认识方法不一样，手段不一样，但是万变不离其宗，都是这么一条思路。

但是经方的理论不是以具体的病位、具体的器官为界定疾病依据的，经方界定疾病的依据不是这个东西。它是什么？它是以人体患病以后，所表现出来的症状反应，并以这个为根据，总结出来的这些方证，这些方剂的适应证来界定疾病的。它就是症状，那么这些症状合到一块儿，它适合某种方剂来治疗，就是用这个来界定疾病的。以肝炎为例，如果患者表现为“往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，口苦”等这一类的疾病，在经方里面就界定为小柴胡汤证。同样还是一个肝炎患者，他表现为“肠鸣、下痢、呕吐”这一类的症状，那么就界定成半夏泻心汤证。这就明确显示出经方理论对疾病的界定标准，是以症状反应来确定具体方证。

那么，我们换一种说法，就是方剂的适应证，在经方医学当中就是最基本的疾病概念。

正是因为这样，才有了经方医学其中的一个特殊的定理。现什么方剂的适应证，就必须要用什么方剂治疗。这就是经方医学的一个定理。

我们说到这儿，大家可能就会明白了，用具体病位、具体的病性来界定疾病，不符合经方理论的基本原则，也不符合它的基本原理。所以，当你明白这一点，你再回过头来去审视那些所谓的三部六病等等。你去审视吧，实际上，只是对经方理论的片面理解。你让他解释经方的疾病是什么？这一关必须得过。你说你在这儿讲了一大通的理论，跟我临床有什么关系？大家注意啊，这实际都是临床当中总结出来的东西，对临床有直接的指导作用。比如，坐在你面前一个病人，他拿出一大堆的不好，心脏又不好，说了一大堆。你心里怎么想啊？我现在有时候，跟病人说你先放这儿，待会儿我看，我先给他做四诊，实际上在我心里压根就不想去看，你跟我说医院的检查是什么病就行了。为什么？我看了那个，我还得是以你症状反应为依据。所以说，这一点非常重要。只要是过了这一关，经方的基本问题就算解决了。

而且这里面还有，对经方方剂的分类，历代注家分类的方法，各有各的特点，各有各的不同。但是，就是因为没有理解到这一个点上，所以说那些个分类，都有各自的侧重，而且都不是特别的合适。好多方剂，放了里证里面，还有表的部分，把它放在热证里面，还有寒的部分，都不太吻合。那怎么办呢？实际上，还是“有是证，用是方”。

澄清了这些理论上的基本问题，下边再来看看这个条文“少阳之为病，口苦、咽干、目眩也”，就是少阳病典型的症状反应：口苦、咽干、目眩。

在实际临床当中，这三个症状在所有的少阳病方证当中，都不是必见证，甚至也不是出现频率最高的症状反应。那么，我们怎么来理解这个条文呢？甚至怎么来理解整个的少阳病呢？我们要解决这个问题，还要回到这个问题的起点。就是所有的经方病理辨证要素的实质是什么？事实上经方理论的基础和核心就是方证！我们刚才说了。就是一个一个具体的方剂的适应证。但是由于人体患病又是非常复杂的，每一个方证，又都是一个动态的症状反应范畴，不是一个固定不变的症状群。

每一个方证都是一个动态的。比如小柴胡汤证，小柴胡汤证“口苦、咽干”也可能出现的，“目眩”也可能出现的，“往来寒热、心烦喜呕、胸胁苦满、默默不欲饮食”这都可能出现的，还有其他的或然证都可能出现的。但是，哪一个病人会把这些所有的症状反应都集中的表现出来呢？也没有。所以说，它是一个动态的，不是一个固定的。

而且，不同的方证之间还存在相同的症状。比如发热头痛，少阳病里边有，太阳病里边也有，甚至阳明病里边有时也会出现。如果我们从这个角度看，给少阳病归纳一句话，一个提纲性的这么一句话，实际上是很困难的。它的基础核心就是方证，而每一个方证又都是动态的，不是一个固定不变的。所以你再去看总结，这是非常困难的事。

说谁不说谁呀？但是经方理论的创建者，面对这么复杂的问题，他借用了“三阴三阳”的这种方法，总结出了一整套的医学体系。这本身就是一个很简单的事，也很了不起。

那么，咱们再来看看这个“口苦、咽干、目眩”，是什么呀？这实际上是大多数少阳病方证当中都可能出现的一类症状。大多数的少阳病方证里边都有可能见到它。比如见到“口苦”，这就有可能是小柴胡汤证、大柴胡汤证、四逆散证，柴胡桂枝干姜汤证。实际上，就半夏泻心汤这一类的方证，也有时候表现口苦。甚至也有人说这个“口苦”是黄芩证，其实没必要这么具体。你越具体，对应的越清晰了，实际上越机械。他本身不是一个固定的，谁能说只要这人有“口苦”，就必须得用有黄芩的方剂来治疗，那也不一定。

他把这三个症状，作为提纲列出来，是不是有这样的用意？第一，可以明确少阳病的病理。因为这一类的症状在少阳病里边出现的几率很高，又不是每个方证里边都必然会出。但是，它能够体现半表半里阳性热证的病理状态。这些症状呢，有这方面的属性。第二，可以代替方剂当中的述症。在其他具体的方证论述当中，特别是半表半里的方证里边，提到这三个症状的几率就相对得少。为什么？因为在这个地方论述了。有还是没有，再去看别的症状，也不一定不是。这样，也就使他的论述变得更为简洁一些。这些症状，不是必见证。加上出现几率不是特别得高，反倒是不如别的证有代表性。他就都集中到这儿说出来啦。那么第三个，他避免形成这个少阳病就是脏腑病变的这种错误概念。这一点，当然这是我们的理解。你去看这些症状，都不是具体的某个脏器，而是一些孔窍之类的部位发生的一些病变。严格地说，这个条文当中的述症，不是所有的少阳病方证当中的总和，更不是全面的一个概括。特别是用今天的论述方式来衡量的话，我们甚至都可以认为，作为一大类型疾病的提纲，用这样的论述方式论述出来，显得有些片面。但是，我们换一换角度，你用简单的一句话，

不用这三个症状，把少阳病再说一遍，你找不到更合适的。所以，真要是用这种简洁的方式，把一大类型的疾病说得非常全面，绝不是一个容易的事儿。

我们通过学习经方也会发现，特别是顶格条文的作者，是非常善于思考，而且在各方面都会想得非常周到的。你看阳明篇里边，降一字格条文和降两字格的条文，那些条文论理的时候比较多，当然有些也是临床实践经验的补充。但是，我们今天再看这些论理，有许多地方经不起推敲。但是方证条文，那绝对是经得起今天，你再往后三五百年甚至上千年，它还是经得起推敲的。“往来寒热、胸胁苦满、默默不欲饮食、心烦喜呕”，就得用小柴胡汤治。二千年以前是这么治，今天还这么治，几百年以后还得这么治。所以说顶格条文的作者，特别得高明。你说他不懂这些道理吗？比如：太阳篇里边的“血弱气尽腠理开”等等那一堆理论，顶格条文的作者不懂吗？他要不懂，他能写出这么全面的一本方书吗！他懂。但他为什么不说？太高明啦！

少阳病^①、两耳无所闻、目赤、胸中满而烦者、不可吐下、吐下则悸而惊、（264）

注：“少阳病”《宋本》作“少阳中风”。

胡希恕：少阳中风啊，他这个意思跟那阳明病中风…啊，后头也有，他都…这都提个中风。那么就是太阳中风这一类的病，而传入半表半里发为少阳病，他也叫少阳中风。就是由太阳中风证而转属少阳病的他就叫少阳中风。两耳聋，无所闻，目赤，这与上面讲的“口苦、咽干”呐，是一样儿的道理。那么这个热要是甚者，不止于“口苦、咽干、目眩”而已，有的时候耳和目也都发生一种…啊，热亢的一种证候。耳热的甚他就聋，啊，目热的甚就发红。所以这在这个少阳病里头啊，也经常遭遇的。一般是口苦、咽干，啊、目眩；甚者有的

时候耳聋、目赤。所以这个…这个柴胡剂啊，对于这个，啊，啊…这个五官的这个…这种证候啊，常有用的机会，尤其这个，啊，耳聋目赤啊，大概这一种的，我们都应该用柴胡加石膏这一种法子好。“胸中满而烦”，这个胸中满而烦呐，有两个看法。一个是“胸胁苦满”，啊。他“胸中满”就“胸胁苦满”的一个互词，他又一种说法而已。“而烦”，啊，在柴胡证他喜烦呐，也就是说这个热它往上冲，上面及于耳、目，啊，口、咽。那么那个…由于往上冲所以胸中也满，由于热往上冲的关系他也是要烦，是吧？这么讲也可以的。说他是柴胡证的一个证候，“胸中满而烦”，就胸胁苦满而烦，啊。咱们头前儿这个柴胡剂他都讲了，在这他就是简单说…说一下子。那么柴胡证这四证啊，啊，胸胁苦满，心烦喜呕在这儿呀，他就把“胸满”和这个“烦”略一提，他言外的意思呢，说是…这是由于…啊，这是柴胡证。这个柴胡证，他就是少阳病初传，嗯…这个初传少阳的时候他发生这个小柴胡汤证。那么小柴胡汤证咱们头前儿讲多了，是不可吐下，啊。那么半表半里的病，它不在里。在里呀，实于上边可以吐，啊；实于心下，啊，以下，可以泻。那么不在里呢？当然就是不可吐下，初发无物嘛。这个病邪没在胃汤里，你，你吃泻药是…只能够虚其胃肠而已，与…与病是毫无收…那么虚了这个胃，这一个…啊，这个寒…要有寒饮的话它就乘之，他“心下悸”，啊，“而惊”，惊则就是躁的意思，惊躁，啊。它比这个一般的这个烦呐，厉害了。这也都是病陷于里的一种证候，啊，甚而惊躁。也可以这么讲，古人说这个气虚也悸，啊，这都指着这个心脏上说的，那么吐下伤气，气虚则悸。那么吐下呢，也亡津液，丧失血液，啊，血液不足，不足以养心，啊，也惊。这是根据呀，咱们的看法，这个…这个…这个古人说是心主神明了，啊，其实这个惊还是脑系的问题，是吧？他古人有这么说的，这也讲的通反正。总而言之，这个少阳中风，假若有这个耳聋、目赤，这…再有胸胁满而烦，这也是柴胡汤证。那么当然是不可吐下，吐下

了，虚其里，邪趁里虚而内涌，啊，则进而为“悸而惊”。

李冠杰：这条在《康平本》是降一字格排版的条文。

“少阳病”在《宋本》是“少阳中风”。

解读一下：

“少阳病”，在《宋本》里改成了“少阳中风”，这个不妥。因为从条文的论述看，它与中风无关。从述症这些症状反应看，也跟太阳病的中风，或者其它的中风无关，没有那种证候。

原文的本意应该是对上一条条文的一种补充。可能觉得提纲条文有点过简了，然后作者根据自己的体悟和经验又作了一个补充，同时也阐明了少阳病的治疗禁忌。可见，这个作者也认为顶格条文的提纲有点过简。如果这条和第 263 条合并起来，不单单可以拓宽少阳病，提高了述症范畴，而且还能进一步明确少阳病的治疗禁忌。

实际上，少阳病的治疗禁忌，顶格条文一共有三条已经论述到了，这个降一字格条文的作者的论述就有点重复。当然，他说了不适合用什么方法来治，把治疗后的不良后果写出来，这是一个比较实实在在的东西。但至于说不适合用什么方子，其实顶格条文里有论述。可是《宋本》中改成了“少阳中风”，就改变了整个条文的性质，使条文有了少阳和太阳表虚证同病的含义在里边，或者说是由表虚证发展而来。但是《康平本》的原文没有那层意思。

“两耳无所闻”，实际就指的耳聋、听力下降或者完全丧失了。在这儿可以理解为突发性的耳聋。

“目赤”，是指的眼白因为充血而呈现红色的一种症状。搞脏腑辨证的认为这是肝火上炎、肝阳上亢的反应。但是在经方理论中，还得结合其它的症状综合来分析，现什么方证就用什么方剂来治疗，是否真正与肝胆有关不重要。

“胸中满而烦”，实际是柴胡证中“胸胁苦满，心烦喜呕，默默不欲饮食”这些个症状的重复，侧重不同。

“不可吐下，吐下则悸而惊”。这是少阳病的禁忌和治疗原则。但是还应该有一个“不可汗”，因为发汗跟吐下所产生的不良后果有些差异。这儿应该侧重于论述“悸而惊”的不良后果，所以只说了吐和下属于误治。事实上，少阳病几乎所有的攻法都不能用，所以少阳病的“正治”，后世总结为“和法”，也未尝不可。

伤寒脉弦细、头痛发热者、属少阳、（265）

少阳不可发汗、此属胃·胃不和烦而悸·发汗则谵语、胃和则愈、

（265）

注：《宋本》此条文如下：

少阳不可发汗，发汗则谵语，此属胃，胃和则愈，胃不和，烦而悸。

胡希恕：“头痛发热”这是太阳病的证候了，啊，咱们头前儿讲了，是吧？那么太阳伤寒，脉它不应该弦细，脉应该浮、紧，啊。要如果发…头痛发热，肯定这是太阳伤寒。那么那个脉弦、细，病在外则脉浮，病在里则脉沉。这个脉也不浮也不沉。这是，咱们讲三部九候这个诊脉呀，这是讲这个，啊，每一部脉有三候啊，就是“浮”以候表，“沉”以候里。就是我们手啊，轻摠，这就是浮取之，啊，这看表有邪；摠，找这个脉，叫沉以取之，这是里有邪。那么这个弦呢？就是中以取之，不浮不沉，这指力呀，就是一般，啊，不轻也不重，这这个时候摸这个脉有了，这个脉较比直，你浮的时候觉不出来。这一个弦呐，这就是少阳脉。所以我们这个弦呐，有多种多样儿，不是说这个脉弦就少阳脉。“浮弦”跟浮紧差不多，这是表实的一种证候；“沉弦”，啊，里边肚子痛也沉弦，这个弦呐，也…也觉…也能够应这个拘急的现…现象。咱们说少腹急痛，这个脉沉弦。总得呀，也不浮也不沉这个弦，就是中取之，这是在半表半里，既不在表也不在里。那么这一个地方比较实，啊，这就所谓这个少阳脉。“而细”，细咱

们头前儿也讲过了，太阳病，十日愈，遂…啊，这个，脉浮细而嗜卧者，外已解也。这个“细”呀，就是“气虚血少”的脉，就是津液虚呀，啊。那么这个少阳病，你像我们头前儿讲那个柴胡证上有，“血弱气尽，腠理开，邪气因入”，这头前儿讲的。那么这个表证的时候啊，这个脉浮紧，你像尤其伤寒脉，他这个血液充实，就是津液当然也是充实了，所以这个脉非常的紧。那么到少阳病了，他这血气呀，都…它都往里面退，退到里面去了。这一个咱们头前讲过了。所以在表的这个，这个脉呀，它就是细了，它里头不充血了，啊，就这体液呀，不在外边了。所以，脉又弦而又细，肯定这是少阳脉，头一段他没提出少阳脉来，在这儿，啊，他又提出一个少阳脉。他说本来是“头痛发热”，太阳伤寒有这一个，但是脉必浮紧。那么现在这个头痛发热，脉不浮紧，而弦细，所以他说属少阳。这一段，这一段呐，他又很有用意了。一个是要辨别少阳病与太阳病就相似一点而来让人加以鉴别。所以头痛有热，啊，咱们现在一看就知道是感冒。这一个感冒是在表还是在半表半里？是有问题的。在表可发汗，那半表半里呢，那不可发汗，是不是？所以这一个很…很…啊，他另有这么一个含意，让你辨这个太阳伤寒与这个少阳的头痛发热一个鉴别点在脉。所以我们辨证也是这样子，如果这个病疑似之间，这个证是可疑的，但是要取之于脉了，再看一看。这一个…这一段就是这个样子。所以这一个，不是太阳伤寒，而属于少阳啊。他搁个“伤寒”呢，当然开始也可以是太阳伤寒转属少阳了。少阳不可发汗，既转属少阳了，那么这一个不可发汗。所以一样的证候“头痛发热”，有可发汗的，有不可发汗的。这一个这是，啊，中医辨证的精神了。这一个一发汗准坏。发汗，他…少阳病不在表啊，你攻表不行，啊，白让他丧失津液。那么这样子就要传里了，胃中干，他就要说糊话了。“此属胃”，啊，这就是阳明胃了，啊。那么这个时候得治胃，“胃和则愈”，我们用药使胃和呀，或者用调胃承气汤了，小承气汤等等的吧，看证候，这

个地方他是，不是说治疗的问题了。使之胃气和，这个谗语就可以好的。这头前儿咱们阳明病篇讲很多了。如果不这样子，胃再不和，就不止于谗语了，是吧？更要进而为“烦”，而为“悸”，啊。这个“烦而悸”呀，烦就是烦躁了，啊。不但谗语还觉烦躁不宁，啊。而且要是心有悸动，这个…这个内热甚了，也影响心脏悸…心脏悸呀，啊。那么前后两段，这都从原则上来论的。他说既是少阳病，啊，也不可吐下，也不可发汗。他与那个…两条儿啊，来把他充足的，啊，分析。那么另外呢，他在这一条上啊，他又提出个少阳脉，啊。这个脉呢，是弦细。那么有的时候，这个病已传少阳了，可是与这个太阳病的证候有些相似的地方。我们头前儿也讲过，说是“柴胡证但见一证便是，不必悉俱”呀，啊。那么他这虽然提出个“头痛发热”，可是咱们在临床上呢，他总有恶心呐，胸胁满这些问题的，啊。他只是就这个“头痛发热”这一项问题，而来区分“太阳伤寒”与“少阳病”的这个不同，啊，这个鉴别法了。这很重要。从这儿我们看呐，这个少阳病治头…这个少阳病了…这个柴胡剂治头痛啊，是重要，啊。这个…在…在临床上啊，我不断…用这一个方子治些病。你看咱们说这个，啊，啊…就是一般的这个病毒性感冒就有这个情形。那真…就像这个乙型脑炎那个疼啊，头痛如裂。那个…那人支持不了那么疼。大概这一种情况啊，要是现柴胡证，你就小柴胡加石膏，那是…那极有验了。那我治很多很多的，啊。那么如果他现大柴胡汤证，舌…舌质也黄了，你就大柴胡加石膏。所以这个柴胡证的这个头痛啊，挺…挺常见的挺常见的。那么这个他也特意提出来了，这个也…啊，在我们通过这一节知道这个，啊，柴胡剂治头痛，这我用它治很多很多头痛。啊…三叉神经痛啊，也有的他没诊断明白，说是这一个，啊，啊…脑肿瘤的头啊，都好使，的确都好使。真正肿瘤呢，我…我治那个，我上次还讲了呢。那他呢，是在宣武区把脑袋都开开了，他这个…打…就是这正头前，有一个…他那个瘤子奇怪，它是骨质的，硬得不得了，

后来那宣武区打开看，不能够动手术，有这么棋子儿这么大，啊。后来他拿那个，就是这个这个注射针这个头啊，心思经他扎…扎进去，或抽出来看看，扎不进去。就这么，这么坚硬。后来给他缝上了，也没告诉病人。后来他的爱人找我给看，我也就用这个方子。不过他那个，我是用的大柴胡，啊，桂枝茯苓丸加石膏，那…那…我上次咱们讲柴胡剂的时候我还讲了。他…他现在这个人蛮好还是。现在，头些日子，在…他是在什么，在福建吧，现在逛杭州去了，老两口，他那爱人是一个工程师。所以这一个头痛啊，这个柴胡证很多，各式各样，啊。但是他“必发热”，啊，这一个，这还是有个有热的。

李冠杰：这是降一字格排版的条文。

《宋本》把旁注窜入到正文里边去，把整个句序都给调整了一下，变成这样：“少阳病不可发汗，发汗则谵语，此属胃，胃和则愈，胃不和，烦而悸”。另外这个条文在《康平本》里边是分为两段的，“属少阳”之前是一段，之后是另外一段。《宋本》把它合成一段了。我们按照《康平本》的结构来学习。

下面解读一下：

先看看第一段：“伤寒脉弦细，头痛发热者，属少阳”。这个条文可以看做是太阳篇第 101 条的翻版，而且那也是降一字格排版的条文。第 101 条是这样的：“伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具”。虽然具体的论述不太一样，实际论述的是相同性质的问题，都是论述少阳病和太阳病同病的情况，第 101 条侧重于原则上的论述，而这个条文则是侧重于明确的述症，这里有具体的症状。

“伤寒”，在这儿有两层意思：一层是初得为太阳表实证，也就是说，是由太阳表实证发展而来的；第二层是说，一发病就是太阳少阳同病的这种情况。

“脉弦细”，它是作为一个典型的脉象来论述的。实际临床中，太阳少阳合病并不一定仅现这一种脉。这个脉象在这个条文里边，还

有用来代表少阳病的这层意思，代表半表半里证，这一点很重要。

“头痛发热”，它既是太阳病、又是少阳病的症状反应，两类疾病里边都有可能出现这种症状反应。如果没有这个“伤寒”，那么这个条文论述的就是一个单纯的少阳病；如果没有“脉弦细”，那么就是一个单纯的太阳病。从这儿可以看出来，在有表证的情况下，有少阳证，“但见一证便是”，它有这个内涵在里边，所以说这个条文跟第 101 条论述相同性质的问题。为什么说它属少阳？因为它有少阳病的症状表现，这儿说的的是一个脉象，也可以是别的证，“往来寒热”也行呀，“胸胁苦满”也行。既有太阳病又有少阳病，就得以少阳病为主。从施治上应该以少阳病为主。这就是这条文的一个落脚点。

下边第二段：“少阳病不可发汗，发汗则谵语，胃和则愈”。另外有一个旁注内容。咱们看一看：

“少阳病不可发汗”，这也是少阳病的一个很重要的治疗禁忌，也是一个治疗原则。

“发汗则谵语，胃和则愈”。少阳病的正治是“和法”，发汗就是误治了，它不但病不得愈，而且会徒伤人体的津液，有可能进一步的发展为阳明病。人体津液虚了，热也常常从中而生。常见的情况，就是出现“谵语”之类的，这一类的疾病，大部分都是属于调胃承气汤证、小承气汤证这一类的方证。所以说这儿用了“胃和则愈”，调胃承气汤治胃不和嘛。

在临床当中，少阳病误汗，实际出现的变证很多。“谵语”既不是一个唯一的证，也不是必见的不良后果。在汉代的时候，很可能这是对少阳病进行误汗之后，比较容易出现的一种症状。

我们现在在临床当中，别说是少阳病误治的这种情况，就是其它的情况，真正的出现“谵语”的这一类的情况很少，就是说能够亢奋到那种地步的，现在的人比较少了。三四十年以前，还时不时的会听说这一类的情况，现在就很少碰到这个。

旁注：“此属胃，胃不和烦而悸”。“此属胃”这一句，是没有用的话，如果它不属于胃的话，“胃和则愈”何来啊？“胃不和烦而悸”，它这是这个作者，对于少阳病误汗之后，出现的某些不是阳明病的这一类的不良后果，机械地去套用正文的这种论述方法。也就是说他在临床当中碰到了这种病人，对少阳病误用了发汗的方法，他就用条文里面这种论述，去让他服调胃承气汤什么的，吃了以后他不是这个证啊，也等于说是误治。他以为要让他胃和一和，人家也没有出现谵语什么的，没有出现那种严重的里热，他也让他服调胃承气汤或者小承气汤证这一类的方剂。最后病不但不愈，反而出现变证了。他就把它写在这儿了，这是他的体会。大家仔细想是不是这么回事？哪来的“胃不和烦而悸”啊？怎么来的“胃不和”呀？那不就说他认为少阳病误汗了以后肯定出现“胃不和”，条文里边有论述，机械地去套用。人家不是谵语，他也让人家喝调胃承气汤，喝了以后，“胃”没有出现“和”的情况，就出现烦而惊了。这不就是误治了么。这么理解反倒是比较合理一些。

本太阳病不解、转入少阳者、胁下硬满、干呕不能食、往来寒热、尚未吐下、脉沉紧者、与小柴胡汤、①（266）

注：《宋本》此处有小柴胡汤方及方后注，此从略。

胡希恕：那么这个就是总结上两节说的了。不管他是中风，或者是伤寒，本来他是太阳病，而在太阳病那个阶段“不解”。那么它转入少阳之后，首先要发作这个小柴胡汤证。“胁下硬满，干呕不能食，往来寒热”，啊，这都是小柴胡汤，很明显的证候了。“胁下硬满”，啊，他说他结于胁下这个地方，就胸胁苦满，啊。他是用这一种，各种的说法来形容这个胁下这个…啊，这个状态。“苦满”，他以满为苦。但是“满”你怎么个形状呢？来这儿他又说了，硬满。你拿…他

们日本讲腹证啊，的确这样子，他沿着这个肋骨弓啊，拿手这么摁，的确有抵抗，那就是硬满，啊。那兵头，那，啊…他，他写个毕业论文，我看来，他还引证…引证这一个，啊，这个柴…柴胡证这个腹证了。“干呕不能食”，心烦喜呕嘛，是吧？同时“往来寒热”，这是柴胡证的这个，啊，很明显，所以这柴胡证俱。那么也这这个时候啊，也没经过“吐、下”等等的误治，而“脉沉紧者”，啊。虽脉沉紧，这个沉紧呐，是里实的证候。虽然这这个时候，有里实的这个脉，但是，你也不…也不能吐下。他这个“尚未吐下”他也不是一句随便说的话，他根据他那个脉沉紧，是吧？这个脉沉紧，这个容易误治的，他对于柴胡的这个证候啊搞不清，啊……（音频缺如）……的情况，仍然可以与小柴胡汤。他是这个意思。那么上面呢…啊，四段呐，他对这个少阳病的，啊，治法，他只提出个小柴胡汤来。可是我们头前儿呢，讲得很多了。啊，讲小柴胡汤，大柴胡汤，柴胡桂枝汤，啊，柴胡桂姜汤通是的。不过这个，在半表半里这个地方啊，他这个，所谓半表半里，就胸腹腔间，他靠近外，啊，他就偏于有表证，你像咱们那个柴胡桂枝汤，他既有小柴胡汤证，又有桂枝汤证，那么他就是这个太阳与少阳并病啊；那么大柴胡汤呢？他既有柴胡汤证，又有阳明里实，那就是少阳阳明并病。所以在这一个部位上啊，他容易…啊，涉及于表，就是表证没罢，那就是太阳少阳并病；那么已经传里，但是柴胡证还完全存在，啊，就少阳证也是存在的话了，这就叫少阳阳明并病。可是这一个，全要掌握这个少阳证，因为少阳证不可吐、不可下。但是你要在…这一个方剂里头同时两解表里或者两解…啊，少阳阳明，这一个没问题的。所以他这书里头很有例子了。他单独的，你要不用…不用这个柴胡剂，啊，而只是去下去，只是去发汗去，这是不行的。这一个咱们也要知道。所以我们，虽然讲一个小柴胡汤与桂枝汤合方，啊，柴胡桂枝汤了，只有太阳病，啊，没解，而少阳病发生了，这是表里双解的法子了。但是可以不可以用其它的麻黄剂

呢？当然可以。尤其这葛根汤，啊，与小柴胡汤是常并发的。尤其小孩子这感冒，它一来了，表证是很清楚，可同时他有半表半里证，胸胁满，呃，呕吐啊，有的时甚至于下利，啊。那么他有这一种情况，你就把这个表…里、半表半里 的方子搁到一起用，是没错误的。这一个我也常用，啊，不但我常用，啊…有一…我一个学生他也常用，啊，就用这个小柴胡、葛根汤合方。所以我们读…研究这个东西呀，他既有这个例子，我们可以引伸。他既有柴胡桂枝汤的合方，我们也可以用柴胡啊、麻杏石甘汤合方啊，或小柴胡汤啊与葛根汤合方，都可以的。根据证候吧，是吧？这一个在临床上咱们也常用的。那么这几段呐，啊，他把他这个，他搁个小柴胡汤，旁的他为什么不搁呢？这个病由太阳病初传少阳的时候，啊，小柴胡汤证，这是在临床上的。旁的他就不说了，都在头前儿了，是吧？所以这个少阳篇，看着…啊，段落非常的少。他就因为在，前…以前都说了，他在这儿，他就提一提就得了。他把小柴胡搁到这个地方了，那么我们可以联想到小柴胡加芒硝，啊，大柴胡汤，啊，柴胡桂姜汤，就像我们方才说，柴胡桂枝汤，全是的。

李冠杰：这个条文在《康平本》是顶格排版的条文。

在《宋本》这个条文后边有小柴胡汤和小柴胡汤的方后注解，《康平本》里边没有。

下边我们解读一下：

“本太阳病不解，转入少阳者”，在这个条文里边可以做两种解读：一是，本来为太阳表证，由于发汗不当，而发展为少阳病；第二是，太阳表证因为失治，就没有得到治疗，发展为少阳病。

“胁下硬满”，这个与“胸胁苦满”属于同类的症状，但是这儿的“胁下”与“胸胁”在部位上略偏于下。而“硬满”呢，其中有他觉症状，与那个以满为苦的“苦满”，也有所不同。这个“硬满”的“硬”哪儿来的？别人能摸到，不仅仅是自我感觉。那么“胁下硬满”

在临床当中，一般是肝胆，或者是脾、胰腺等器官的病变比较多。而“胸胁苦满”，就是胸腔内的器官出现病变的几率，会比较多一些。但是这些都属于小柴胡汤证。

从这儿，可以看出一个规律，如果仅有心、肝、脾、肺、肾这一类脏器的病变，而没有上述症状的，那不一定属于柴胡剂的适应证的范畴。但是，如果有上述症状，而没有具体的脏腑病变，仍然为柴胡剂的适应证。这就印证，怎么去理解病位，关键问题还是一个症状反应。这个症状反应才真正反映的是疾病的实质。有时候某个器官的具体的病变，但那不是病的本质。为什么？有可能同样得这种病的人，是在不同的病理状态下得的，那反倒不是疾病的本质。

“干呕不能食”，就是“默默不欲饮食、心烦喜呕”这一类的症状。但是“干呕”跟“喜呕”有一点区别。“干呕”是呕而无物，吐不出东西。“喜呕”既包括干呕，也包括有食物吐出来的呕。这个“不能食”明显比“不欲饮食”，在程度上比较严重。那么我们为什么比较这个啊？本身就具有意义的。实际上，不是完全的重复。

“往来寒热”，是完全重复了。这个是典型的少阳病的症状反应。

“尚未吐下，脉沉紧者，与小柴胡汤”。因为这个条文的述症，与小柴胡汤证典型的症状反应或多或少的都有出入。特别是“脉沉紧”，这不是少阳病的典型的脉象。所以，在这儿就特别强调“尚未吐下”。意思是什么呀，要是经过“吐下”，再表现为沉紧脉，他就有可能存在里证。那么，有柴胡证又存在里虚寒证的话，用柴胡剂治疗，是不行的，肯定要出问题。所以，这是作为一个警示放在这个地方的。尚没有吐下的，出现里证的可能性，相对要少一些。这里也没有用小柴胡汤主之，而用了“与小柴胡汤”，示意你一定要仔细辨证。

这个条文论述的就是因为太阳病失治，而发展为少阳病的情况。但是此类，太阳篇已经有论述了。所以，顶格条文的作者，就在少阳篇里边，特意论述了一种，还有这一类的情况。

明显地我们能看出这个述症，要比真正的小柴胡汤证的“往来寒热、胸胁苦满、默默不欲饮食、心烦喜呕”要重一些。原因是什么？原因就是人体要比那一类的，可能会更虚一些，体质更差一些，他就容易出现这个情况，病也会重。正因为这样，这个条文在少阳篇里边，就有多方面的含义：既是在这个篇里边，作为确定少阳病基本类型的论述。那么少阳病的基本类型是什么？这儿给你点了一个小柴胡汤证。实际上，就等于点了柴胡剂。你可以举一反三。同时，又论述了小柴胡汤证当中，偏于重症的一些症状反应的特征。像“胁下硬满、干呕不能食、脉沉紧”，这都是。另外，暗含有如果经过误吐误下，而现“脉沉紧”的，那就要细辨有没有其他类型的疾病存在。等于是警示读者。

我们做一个小结：患太阳病后，因失治或治疗不当，而发展为少阳病，症状表现为：胁下硬满、干呕不能食、往来寒热，而且尚未使用过吐下方法治疗的，即使现脉沉紧的，也可用小柴胡汤治疗。

若已吐下发汗温针、谵语、柴胡证罢、此为坏病、（注）

知犯何逆·以法治之·（267）

胡希恕：这以前我们对这个柴胡证论得很多了。说，如果…啊，发汗或吐下，那么柴胡证不罢呢？那虽然这个下之不为逆，还可以给柴胡汤。这个都在头前儿都讲了。那么在这儿呢，他说的这个，变成坏病要怎么办呢？坏病当然不能用了，啊。所以我们得前后看。他这个…他这个说的这个，都是前边没这么说的。他又变个方法说，他说若已经，啊，误吐，误下，误发汗，啊，误用温针，这热不能用温针治疗。那么这个人已经谵语了，啊，柴胡证没有了，柴胡证罢，这个时候你不能认为以前是柴胡证，现在我还给你吃柴胡汤吧，这一个不行，啊。“此为坏病”啊，这是通过误治造成的坏病。这一个不能

吃…啊。所以中医这个辨证啊，就是现时，你昨天怎么的，你今天没关系的，啊。但是我们也问证作个…啊，作这个病的这个考虑，啊，可以。但是，那一个不足以为凭了，今天你有什么证就用什么法子治疗。这是治坏的病了，这个时候我们要看现时，“知犯何逆”。这个“知犯何逆”呀，大家这个，啊，注家解释也很不同的。有这么解释的，说这一个，这个逆呀，那来的？是吐来的呀，下来的呀，或者汗来的，或者温针来的。我认为这一个不妥当。这个辨证啊，根据现…现况，这个“知犯何逆”就是现在的结果，啊，你是属于那一个情况，啊。逆治的结果的情况，他是说的这一个，啊。那么你是什么证，我就用与你什么方法治疗，依法治之。这一个是对的。你是调胃承气汤证啊，这个谵语嘛，这已经这是，啊，嗯…他是入里了；你可是，啊，白虎汤证啊，可是小承气汤证啊，等等的。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格条文。

解读一下：

这条论述的跟上一条内容既有联系又各有侧重，虽然它分了两个段落，但是在论述上有一定的衔接，有重叠的关系。

“若已吐、下、发汗、温针”，几乎囊括了所有的攻法治疗。实际上就是想说如果用攻法来治疗少阳病，会出现不良的后果，或者出现变证。等于是论述少阳病的治疗原则和禁忌，这个地方论述得就已经很全面了。

“谵语”，应该理解为是以一个具体的症状，来说明疾病已出现了少阳病以外更为严重的情况，这只是举个例子。在临床中，像少阳病用下法，出现里虚寒证的可能性也有，比如出现理中汤证完全有可能，体质弱的甚至出现四逆汤证也有可能的。但不管出现什么样的变证，按这条论述的精神，都属于“坏病”。具体的是用“谵语”（也就是说形成了阳明病）这个比较典型的阳明病症状举例来说明。

“柴胡证罢”这一句，可以跟第 103 条里的“柴胡证仍在者”做

对比。那条论述的是在“柴胡证”的情况下，反倒是二三下之，如果柴胡证仍然在的还可以用柴胡剂来治疗。这一条论述的却是柴胡证不在的情况，“柴胡证罢”了，是说疾病因为误治，已经脱离了少阳病的病理阶段的情况。

“此为坏病”，可以理解为因为误治，疾病已经由半表半里证转变为其他类型的疾病了。

这条文后边的注解加的也是挺好，就是“知犯何逆，以法治之”。它应该是对上述出现的“坏病”的一个原则性的治疗办法。意思就是说一旦少阳病消失了，表现为其他类型的疾病时，就要重新辨证施治，符合什么方证，就用什么方剂来治。

做个小结：柴胡汤证，如果经或吐、或下、或发汗、或温针等误治后，患者表现为谵语等非柴胡汤证症状，且柴胡证已消失的，即为坏病，需重新辨证施治。

三阳合病、脉浮大、上关上·但欲眠睡、目合则汗、（268）

胡希恕：三阳合病就是既有太阳病，又有阳明病，那么再有少阳病，这一个同时发作的，不是有先有后，啊，这就谓之合病。那么有太阳病的发烧怕冷，啊；那么阳明病呢？啊，大便干呐，或者胃家实等等这一种情况；那么再有少阳病口苦、咽干这种情况，搁到一起，这叫三阳合病，同时发作。那么这个证候他没说明，他也就脉上来说一说。那么就这个脉上说这是三阳合病，脉浮这是太阳脉；脉大，阳明脉大，这是阳明脉；“上关上”，这个上关上啊，咱们这不是关嘛，靠着关上边一点，就叫上关上，啊。上关上，关，啊，那么，关以下，啊。他就是下，下与关。这个“上关上”这个地方啊，是以候心下之积。这个《金匮要略》就有，啊，《金匮要略》你们看那一个，啊，啊…积聚那一章，啊，他说是这个上关上以候心下之积呀。我们讲这

个少阳病啊，他就是在这个胸胁，啊，主要在胁下，胁下跟心下，这个上下的部位说是相当的。那么这一个上关上，以候少阳之邪呀。这个三部九候啊，是，是这一个，啊。三部：就是上以候上，下以候下，中以候中了，啊，这是粗糙的说。那细着说那，那，啊…就是我说这个夫诊脉大法，当取太过不及。就是那一个癥瘕积聚，啊，他说…他讲的非常的…非常的好。他说这一个浮大之脉，峻…显现于上关上，那么这一个，冲这个脉上说，这个上关上少阳的，诊…候少阳之邪，那么这一个地方啊，脉浮大，这也是少阳有热，是吧？所以他来就这个脉上说的，啊，这为三阳合病。这个三阳，啊，一会儿我们再好好讨论讨论呐。这个阳性证啊，它都是亢奋的、热性的，是吧？那么这个三阳都是一个热，这就是表里内外全热了。这一个在《内经》上有这么一句话，所以气食少火，啊，壮火食气。这个人一点温没有不行呀，啊。你…可是啊，得不大温，少火，人这个气就能生，啊；但是火大了，伤食人气了，所以他说“壮火食气”。那么这个…三阳同时有热，内外表里，这是壮火了，啊。人…伤人气者，所以但欲眠睡，啊，目合则汗，这个气虚呀。那么再说呢，就这个热的…在里蒸的一个现象，啊，内外具热呀，啊，所以这人昏昏欲睡，啊，而盗汗出。“目合则汗”，就是盗汗了。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降一字格排版的条文。

咱们解读一下：

“三阳合病”，是指太阳、阳明和少阳同时发作。说明人体各方面的机能都处于一种病态的亢奋状态。

“脉浮大”，应该是三阳合病的情况下，常见的一种脉象。虽然临床当中不一定仅现这一种脉象，但在这个条文里，它可以用来说明这个时候，人体处在一种机能亢奋且热象明显的状态下。

旁注“上关上”，本意指的是这种脉象，集中于关脉的上部。因为这个注解，将脉象论述得过于具体了。这实际上里边就包含了，三

阳合病，就现这么一种脉象。但是大量的临床资料证明，任何一个方证，都不是仅现某一种脉象。如果这个“脉浮大”是常见脉象，同时又用来说明病理特征的话，那么作了这个注解之后，就把这种论述给僵化了，就没有那个灵活性在里边了。

“但欲眠睡”，这儿应该是少阳病了，嗜卧的因素在里边了，同时又有阳明里热，致人昏昏欲睡的这么一种因素。

“目合则汗”，就是指盗汗。这儿主要是因为里热所致。盗汗实际上在临床当中，它可能是由于许多病理因素造成的，大家不要一碰到有盗汗的人，就认为他有热，不一定。比较典型的像少阳病和表虚证同病的柴胡桂枝汤证，这个常见有盗汗的情况，特别是小孩；白虎汤证也有盗汗的，那就是睡醒了以后，有的汗出得很多；甚至四逆汤证，也有可能出现这种情况。虽然说都表现为盗汗，病理相差很远，不能单纯地、机械地去看盗汗。

少阳病既不能发汗，也不能泻下，所以说三阳合病的情况，应该先取少阳而治。这个条文论述的算是三阳合病中的一种表现形式，言外之意，就是应该从少阳而治。这也就是这个条文出现在少阳篇里面的用意所在。

伤寒六七日、无大热、其人躁烦者、此为阳去入阴故也、

(269)

胡希恕：这个六七日是指病自表传里的一个一般的一个时…啊，一个情…一个期间，头前儿那都有了。伤寒五六日，啊，无论是中风啊，或者是伤寒呐，啊，这个时候都要传半表半里一般。到六七天呢？这是传阳明的一个期间。“无大热”，这个热结于里，外无大热。所以咱们，咱们讲那一个，啊，陷胸汤证，啊，也是就有这一个，啊，外无大热，可是热结到里头了。“其人躁烦者”，这个表热表不解，

人则烦呐。这个热在里，人也烦，更烦，所以他躁烦，啊，这个躁就是头前儿说的惊，惊躁，是吧？乱，就是躁扰不宁呐，人一点也不宁静。烦者热也，再有热。那么这一个热呢，不在外了。他外无大热，啊。而且六七天的时候要这个情形啊，肯定这个热传里了。“此为阳去入阴故也”，古人这个阳啊，他是所主外。这个外，啊，没有了，这入里了。这一个“阴阳”指着表里说的。这一段，按理说也不应当搁这儿，啊。他认为这个讲这个病传了，他说这个，这个太阳病啊，有传入半表半里，经过半表半里再传入里的，有这么一种情况；另一种情况呢，这个太阳病有直接传里的，这一段就说明这一个。他头前儿因为提出来一个又中风又伤寒的这个传变，他说，可是一样要加小心，啊，在六七天这个一般传的时候，他常常直接传里，这一个与少阳病无关呐，啊。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降两字格排版的条文。

咱们也解读一下：

“伤寒六七日，无大热，其人躁烦者”，论述的是初患为太阳表实证，因为长期得不到合理的治疗，而致病情发生了质的变化。“无大热”，应该理解成没有太阳病典型的症状反应。那么“其人躁烦”呢，这是出现了阳明病的症状反应了。

“此为阳去入阴也”，这儿的“阳”与“阴”应该理解为什么呀？理解成外与里。那么“阳去”就是表证已经消失了，“入阴”就是进一步发展为病情更为严重的里证。

这个条文论述太阳病如果失治，日久可能进一步发展为里证，是这么一个意思。但是，这个条文出现在少阳篇里边，所述的症状，又是明显的阳明病常见的症状。我们只能理解成这是一种没有发展为少阳病的情况。那么言外呢，有太阳病失治，并不一定只会发展为少阳病这么个意思。

伤寒三日、三阳为尽、三阴当受邪、其人反能食、而不呕、此三阴不受邪也、（270）

胡希恕：这一段肯定这是王叔和搞的，他这个书讲的表里相传呐，啊。这一个不是了。这一个一日太阳，二日阳明，三日少阳。四日呢，应该传太阴。他说这个伤寒已经经过三天了，啊。一天、二天、三天，这是三阳为尽了，这个三阳传遍了，头一天太阳，二一天阳明，三一天少阳，那么四一天呢，啊，应该传太阴。太阴什么情形呢？那，下边咱们就有了，“太阴之为病，腹满而吐，食不下”。“其人反能食而不呕”，说明它没传太阴。这根据，这个是根据《内经》上的话，啊，这个“此为三阴不受邪也”，既没传太阴，更不能传少阴、传厥阴。他…他递传嘛，他根据这一个说法。这是三阴不受邪也。这个病啊，啊，可以在阳证这个阶段就可以好的了。这是这个书的原词，是这个话。但是这一个与张仲景这个书不相符。你看他这个书，啊。我们讲太阳病，咱们这三阳篇讲完了。太阳病有传阳明的，所以在阳明篇，你看那写的非常清…清楚。他说阳明病，有太阳阳明，有少阳阳明，何谓也？他说太阳阳明由太阳直转属阳明的，也有从少阳转属阳明的。他这没有那么一…你前后你翻吧，不但三阳…三阳篇没有，以后也没有。没有再从里，再往外传到少…啊，传到半表半里少阳病的，没有。所以少阳病你看，也没有。那一个是从里传的？全是从外。他这个讲表里相传，啊。外往内，内往里，也有外直接传到里。这是他这个书，前后这是一致的。那么这一段呢？可见不是了。所以这一书坏呀…这个王叔和这个人是个好人，是吧？咱们现在说他是这个对中医有功啊。如果他要不收集张仲景这个遗论，恐怕现在我们这伤寒论也没有。但是这个人呢，他不怎么好名，治学的这个态度相当的好。但是他有些已见他加里头，他不提。他就是在这个在伤寒例他提了，啊，说自己做的。你像平脉呀，辨脉呀，这都是他的。跟他那个《脉

经》上都是一…差不多，他不说他…他做。哈哈！那么这儿也是，他不是…他的意见他往上加。咱们现在这个各家注解《伤寒论》呐，都根据《内经》啊，这是，王叔和头一个。那一个成无己本，那头前就有，就有那个伤寒例，这个赵开美本没有，他给…知道是王叔和的，他都给弄去了。啊…成无己本上的伤寒例，那与张仲景这个《伤寒论》是一点也不一样啊，那是王叔和的。他那自己也说的，啊，他说他怎么怎么的，头一句话就是阴阳大论曰。所以这个《伤寒论》，啊，那么大家都是，说它在《内经》基础上发展起来的。这个王叔和是…啊，首先他这么看的。他这个伤寒例就看出来了。由于有这个伤寒例，所以后来才出具，出来《伤寒论》这个序儿。这个序言呐，所以这个，他说是那个“撰用素问、九卷，阴阳大论”，全是说的王叔和这头前儿这个伤寒例。可见这个序言呐，在王叔和那个时候没有，叔和那个时候他这个书也不是两本。你看那一个，啊…《金匱要略》头前儿那个序言就看出来了，啊。一发作的时候，他那个书啊，前是伤寒，后是杂病，啊，第三部分就是方。他把这个伤寒杂病的方儿都搁到后头了，这一个恐怕还是原来的本。那么到这个晋后、晋末的这个时候，啊，是到南北朝这个时候，那乱的很。他这书啊，大概在宋的时候才分开。你看看，林亿他们发现呐，那个时候，他…他先发现这一本，那个《金匱要略》啊，他后发现的，啊。在那个林亿那一个，啊，那个记载就看出来了。所以那一个时候啊，他把这两个书啊分开了。在王叔和并没分开。可是王叔和也没那个序儿，怎见得呢？你看看皇甫谧就看出来了。皇甫谧跟那个王叔和呀，他们是前后这个差距非常小，他们生这个时代。王叔和，那谁，那个皇甫谧很赞美这个王叔和，说是王叔和选这个仲景遗论甚精啊，用之多验。而且他说这个，伤…说这个张仲景这个书啊，是论广汤液而来的，论广汤液为数十卷，啊。说晋太医王叔和，啊，这个选论甚精呐，用之多验。那么可见这一个…这个皇甫谧他也没见着这个序言。你们想一想，咱们要看书有序言，

人家自己都说是撰用素问九卷，他就能说他是…啊，论广汤液？不会的。所以皇甫谧那个时候啊，就没有这个序儿。这个序言呐，恐怕在这个南北朝，就是，啊，五代这个期间，看这个王叔和这个伤寒例，他那是依本《内经》，啊，所以才出来这个假序儿，这个序言是个假的。这个文字与这个…与这里头…也…也不是一样的，啊。他这个语言 音声啊，都是一致的东西。要这样子，所以研究伤寒论呐，哎，就是附会《内经》，越附会越吃力，啊。咱们一会儿后再谈那一个。那么王叔和呀，他在这里头，他也不加以补充。你像这一个，跟下边这个全是。

李冠杰：这个条文是一个降两字格排版的条文。

“伤寒三日，三阳为尽，三阴当受邪”。这个意思是一日太阳，二日阳明，三日少阳，是这样的一个疾病传变过程。那么伤寒三日了，就是三阳已经传尽了，疾病将要发展为三阴病的阶段。实际这是《内经》的理论。

“其人反能食而不呕，此三阴不受邪也”。虽然日数已经到了传入三阴病的时候了，但是并没有出现相应的证候。“反能食而不呕”，是对着太阴病“腹满而吐、食不下”。“反能食”对“食不下”；“而不呕”对“腹满而吐”。就是没有出现阴性证。没有发生三阴病。所以后边“此三阴不受邪也”。

这个条文本来要论述太阳病，患病多日以后，不发生里证，甚至自愈的这种情况。但是这个条文，却是典型的以《内经》的理论，来解释经方理论的论述。不但与经方医学不是一个理论体系，而且逻辑混乱，更没法与临床实践接轨。临床当中是非常复杂的，哪有这么机械的，这都是不可取的。

伤寒三日、少阳脉小者、欲已也、（271）少阳病欲解时、从寅至辰上、（272）

胡希恕：伤寒三日，理应转属少阳。那么转…转属少阳，脉不但小它要弦呐。只小而不弦者，这邪…啊，这邪已微呀。那，这个病要好的。那么这也根据一日太阳，二日阳明，三日少阳说的。这一个也是，一个人手笔，啊。“少阳病，欲解时，从寅至辰上。”这一个，每一章后头都有这么一句话。这一个也是属于王叔和的，啊。这是个照例文字，这个东西是不是准确，我可没…没考验。但是没有什么大意义。这有…有也就是约略之词吧。那么这样子，就把少阳病咱们讲完了。

李冠杰：这两条在《康平本》都是降两字格排版的条文。

在《宋本》里“欲已也”之前为第 271 条，之后为 272 条。

先看看第 271 条：“伤寒三日，少阳脉小，欲已也”。本意是想论述表证经过三天左右，表现为较为平和的脉象，则说明病势不重，有自愈的趋势。但在论述上，与上一条一样套用了《内经》的理论来解释经方的概念，来论述疾病的发展规律。它认为三天应该到了少阳病的时候了，但是“少阳脉小”，就是说这个时候是少阳病了，但是现小脉，“欲已也”的意思是就要痊愈了。这不仅与经方理论相悖，而且与临床实践也不吻合。在经方理论里，表证在三四天的时候，通常才仅仅有发展为少阳病的可能，而不是象它说的那样已经是了。而且这只是一种常见情况，太阳病保持七八天、十来日的疾病性质不变的，有得是；病势重的，二三天也有发展成更严重的，甚至发展为里证的也有。经方的论述里，既有通常的规律，又有特殊的情况。绝对不象这条论述的伤寒三日就必为少阳，绝没有这种道理。

但是也不能说没有可取之处。就说当脉象和症状相互矛盾的时候，有时可以说明一些问题。在这儿说一个实际临床的病例。去年，

我邻县一个七、八岁的小女孩被她父母带来看病，之前因为发烧厉害，吃了点退烧的西药出了汗，体温也不高了，看着孩子玩得挺好。我摸了摸脉，脉数急，跳得很快！我说孩子还要发烧，我就让她家长用饮料瓶子把我做的药泡上，带在路上喝。她家长回去以后就告诉给我：虽然在路上让孩子喝了药，但是回去后孩子体温还是烧上来了，之后又接着喝药才慢慢恢复。她大概是误治了，少阳病还在，我给的是小柴胡汤加石膏，喝了以后又烧了一天才好了。

下边是第 272 条：“少阳病欲解时，从寅至辰上”。意思是说少阳病如果得愈的话，则会在每天的 3 点到 9 点这段时间。像这种条文六经疾病里都有一条，与临床实践不符，不足为训，咱们知道这么回事就行了。

少阳病小结

胡希恕：这个少阳病总结很好总结，啊。这一个书，只是在原则上讲了，少阳病的特征，啊，由中风伤寒传来的，啊，那么这种情况。由中风来的，中风他多热，啊，所以不止于“口苦、咽干、目眩”，甚至于，啊，耳聋、目赤。但是既传入少阳，他都有胸胁苦满，而烦。那么要有这个情况，这柴胡证，这不可吐下，啊。那么这个伤寒呐，也是一样。伤寒他又是，意思更较比含蓄多，一方面给这个太阳伤寒

与少阳病的一个，啊，就这个“头痛发热”，那么这是鉴别的一个法子。那么，当然证候是一个了，但是要…要辨脉的。他这个脉弦细，他把这个少阳脉呀，也说出来了。那么这一系列都是原则上的，他这个治法呢提出个小柴胡汤，那么言外其它的柴胡剂也是，都在头前儿呢。那么至于后面，是吧？合病他也是略略一提呀。那么头前合病也有啊，是吧？无论是合病并病，依法呢，应该主治少阳。我们可以，啊，偏于表的，柴胡剂与解表的方剂，合方可以。但是只是发汗是不行。偏于里的，我们用柴胡剂兼攻里可以，只是攻里不行，啊。所以这一个，我们对这个，前后看，啊，就明白了。

李冠杰：少阳病篇顶格条文只有三条，虽说数量不多，却言简意赅，几乎囊括了所有其它篇章里没有详细论述的少阳病要点。

第一条顶格条文是第 263 条，已经解释了，用了三个少阳病方证经常可能出现的或然证，作为少阳病的提纲，我们解释得非常详细了，就不再进一步去回顾了。

第二条顶格条文是第 266 条，以对小柴胡汤证的一种特殊情况的论述，既阐明了少阳病的典型方证类型，又补充了其它篇章中有关小柴胡汤证论述的不足。它跟其它条文有关小柴胡汤证的论述形成互补，其它地方没有这么严重。

第三条顶格条文是第 267 条，它论述了少阳病的治疗原则和治疗禁忌。这条虽说文字简，但是意义重大。有关少阳病的治疗原则在太阳篇章和其他篇章里都有论述，按照经方的论述方式，在其他条文里已经论述过的一般不作重复。但是这条把所有的误治又集中在一起论述，目的在于以柴胡剂为例，阐明凡是不可用攻法治疗的阳性病都有少阳病的属性。大家想想是不是这么回事？

虽然这篇论述的典型少阳病是小柴胡汤证，但是小柴胡汤证以外还有若干少阳病性质的方证，或者说有这类的疾病。它们的特征就是不能用“攻法”，也得用“和法”。这一下就把问题给点得很清楚了，

用不着把一个个的方证都论述出来，这是说得很重要的一点。而且还阐明了这类的疾病误治以后，如果疾病反应没有发生变化的，仍然可以用相应的半表半里方证来治疗，这是在太阳篇里论述的；一旦脱离了少阳病的病理阶段，就要另行辨证施治，这才是本条要论述的重点，这就是跟太阳篇里的论述形成互补嘛。

虽然这个治疗原则也适用其它类型的疾病，方证相应嘛。但是在少阳病里，这种属性更为突出。因为三阳合病中只要见到少阳病，整个疾病的趋势就以少阳病为重点，所以少阳病在三阳病里是很重要的，特别是施治上是影响最大的。

上边这三条顶格条文，已经足以把全书中有关少阳病的相关论述都联系起来了。第一条它说有可能出现“口苦、咽干、目眩”的这类方证，就有可能是少阳病（“少阳之为病”嘛）。然后少阳病的典型方证是小柴胡汤证。再接下来少阳病在治疗上的特点是既不能吐，又不能下，又不能发汗，也不能温针，具有这些特点的方证都可以视为少阳病。是不是就把少阳病说得非常清晰了？除了顶格条文，其它的条文学术价值不是很高，就不再进一步地讨论了。

另外有一点要强调一下：如果从全书的论述结构上看，这个少阳篇是在阳明篇之后，又进一步地做了一个示范。少而精的论述内容示意读者，只有通过整体地解读和理解经方的全部内容，才可能全面认识一种具体的疾病类型，这一点很重要。因为后边有的条文比这个论述还简呢！

三阳篇总结

胡希恕：我们把这个书啊，这个三阳篇好好，啊，温一温，谈一谈，等我喝点水，咱们稍稍休息一会儿。……把这个病分两大类啊，啊，这在中医辨证上，主要是阴阳。由于这个病的发生啊，他咱们这个脉法也这样子，它是不太过便不及，全是的，证候也是。那么也就是这一个，啊，矛盾是普遍存在的。我们讲这个阴阳啊，就是矛盾的两个方面。你看看，上、下，这是个矛盾了，但上呢，就是积极的一方面，啊；前后也是一样的；好，啊；美恶，美就积极一方面。他把

这个积极这一方面呐，都叫做阳，把这个消极这一方面呐都叫做阴。这是咱们这一个，啊，讲这一个，古人用这个阴阳啊，用这个… 啊。那么他就给这个矛盾这两方面起的。可在证候上，什么叫做积极呢？就是兴奋的，啊，发扬的，啊，热的，这都是。抑制的，啊，沉衰的、消极的方面，这都是个阴，阴证。我们在临床上也确实能体会。所以这个病的发作呀，它只是这么两个方面。现在我们量血压什么，都是这样子，它不是高就低了。不高不低这血压就没病啊。所以人一有了病了，你这个…在这个生理机能啊，它要改变，首先改变咱们就说代谢机能。这一个改变呐，它亢进这一方面，就发生这阳性证，啊。你像痛啊、呼、喊、叫啊，这个脉也是又大、又快、又浮、又实，都属于这个太过的这个形象，这就叫做阳；有一种病发作呢，哎，它一个，消沉的样子，你像人呐，昏睡不醒啊，啊，身上也凉啊，一摸这脉又沉呐、又微呀、又细呀、又涩呀，这都，这一种脉，这都是属于不及的这一方面了，他叫做阴。那么这个阴阳哪来的呢？还是我们生理的机能的关系了，是吧？那么主要是代谢机能啊。有了病这个，啊，他就使之机能改变，这个改变就是这么两个方面，一个是太过，一个就是不及。那么太过古人叫做阳，不及叫做阴。就是这么个东西。那么首先他这个疾病万变呐，只能这么两类，啊，不是阳就是阴，也不阳不阴你就没病，这古人就这么个看法，这很…很简单个事儿。那么这一种病的反应，他古人他看的证候反应啊，在哪儿反应啊？它离不人身上你可知道？哎，反映到表，这个表就是体表之表了，就是咱们说这个躯壳，身疼啊、脑袋疼啊、都在体表，关节疼啊什么。这古人叫做表，这就是，啊，反应到这个表上的阳证，我们就管它叫做表阳证，就这个书上太阳病；那么这一种阳性证呢，反应到里，这个“里”呀，这很好体会，“阳明之为病，胃家实也”，你从他这个你就知道，这个里指着消化道里面，那么这叫做里证；也不是在体表，也不在消化道里，半表半里证。来哪儿呢？就是胸腹腔间。一切脏器都属于这一

套的，都是属于这个半表半里的范围。这头前儿啊，这是我们说是这一个三阳证，啊。什么叫阳证？可是这个…这个…这个证的反应，它得有个着落有个处所呀，那么就是表、里、半表半里。他古人呐，他通过临床啊，也是经过很长时间他看出来了。他这疾病啊就这么两个方面。他阴阳，他脑子有这么一个结论。然……（音频缺如）……三阳证啊。那么我们讲三阴呢，就是三阳三阴证了。哎，所以这一个，这就是古人呐，限制于科学水平了。当然是，那个时候就有经络学说。他说这一个，啊，这是六经的问题，所以咱们搞出六经来。咱们那个太阳，啊，本来太阳就是表阳证，阳明就是里阳证，这个少阳就是半表半里的阳证。可是古人呢，都给它起个名，太阳证，啊，太阳病、阳明病、少阳病，啊。那我们现在要问了，为什么病它有这个…只反应这么三个方面呢？还有旁的方面吗？这一个值得研究。所以咱们今天这就是，啊，借这点时间，咱讨论这些问题。他这一个，所以古人这一个也看出来了，古人看个什么呢？说人的这个人体呀，它是遭受外边的侵蚀，它就要抵抗的。就是咱们这个书里写这个“正邪交争”，我认为这一个它是中医一个大发现。也就是这个人有了疾病了，不是这个疾病在那儿，自己在那儿往前…啊，进展呢，这是人与它斗争，这个人的机能与它斗争在那儿…造成这个证候的反应。古人这么看的，这个很有道理了，啊。与我们治疗这一个也很…很…很…啊，也是很有指导必要。这个首先，这个《内经》上这个，你们回头看看那评热病论它就有这么一篇，他说人之所以汗出者，皆生于谷，谷生于精。他这头一段的意思啊，他说我们这个出汗就是谷气，这谷气怎么就变成汗呢？他说这谷气呀，能化成精气。那古人说这个精气呀，就是养人的一种珍贵的东西。拿着我们现在说呢，就是营养成分。你饮食入胃，他吸收过来的东西就营养成分。他说这汗就这么生的。然后他…他就说这个正邪的分争，你看说的非常好。今，啊，邪气交争于骨肉，他说在表的时候，就是外邪和我们人的精气来体表打仗，交争

于骨肉，骨肉之间嘛，这也是躯壳嘛。他说而得汗出者，出了汗了，那就是精胜也。啊。就是打胜仗了，咱们机体这一方面打胜仗了。打胜仗了，所以达到出汗。可是，真打胜仗了，他不能再发热了；真打胜仗了，这个，他自己头前儿也说了，他说这个，啊，汗来自于谷气呀，你真打胜了，这个胃当然是很亢奋，当能食而不复发热。可是现在呢？这个人不能吃，热还在那儿，这说明打败了，哈，哈！啊，这是精却邪胜也。那么出这汗是什么呢？那是你这个，这个正气呀，就是所谓这个精气呀，泄于外了。再不能吃东西，精气也没有什么补益了，那只是把这个邪留到里头了，这了不得，他叫阴阳交嘛。这一段说明什么？我为什么征引这一个？这个《内经》上这一段挺精啊。他就说的病在表的时候，表证，就是…利…人利用这个，啊，水谷之气，与外来这个邪气它在这一块儿抗拒，在体表这一块儿抗拒。你看看，咱们拿这个，表证这一个证候你好好想一想，是这个不？一点也不错呀。你像脉浮，头项强痛，而怕冷，是吧？他说太阳病吧，这太阳病的特征了。他为什么这个脉浮啊，头项强痛啊？这个脉浮就是里头充血了，他不是血多了，他是尽量的体液呀，尽量往体表上来，他也打算出汗。所以，你们研究研究，看看这个，啊，这个，啊，这个生理学上大概就有这一个。是人要出汗之前，他这毛细血管都扩张，就是浅在的这个血管。它扩张了，他内部这个水分它尽量往外边来嘛，所以这个血管达到极充血的一个…一个情况，尤其上半身最厉害，所以脑袋呀、脖子啊，这个血管啊，那个充实得更凶。这一个咱们都得过感冒，得感冒时候，你摸这个，好！这个脑筋都崩起来，尤其上边越厉害，所以头也特别疼。他这就是一个压迫性的疼痛，啊。上边最…最…最厉害。这就是要出汗不得汗出的一种情况啊，啊。脉浮，头项强痛。为什么怕冷啊？那不是寒在那儿呢！他这一个，由于液体的，啊，往这个外来，充实于这个体表。这个热也在液体里头啊，他这个体温，这个体表体温，它特别加高。我们平时与外边这个空气这个接

触啊，它是一定的差距呀，这一阵儿加大差距了，本来外边儿也没风没寒的，这阵儿就感觉寒的刺激。他是这么一个。所以咱们古人呐，常常的把现象当本质。恶寒呐，这就是受了寒了，恶风就是受了风了，这不对的。他应该是这么解释。这一个就说明，这个人体打算出汗，他出不来。咱们讲麻黄汤不有个“阳气重故也”嘛，啊。尽量呢，把这个体液往外输送，都在体表上呢，人发烧受不了，脑袋疼的，啊，乱蹦，他就出不来汗。那么，那个…桂枝汤它讲出汗，虽然出汗，他这个精气呀，不足以祛邪。出了汗了，这邪气反倒深入了，啊。说是，桂枝本为解肌呀，他还是想让他再出汗，啊，但是他不是像麻黄那一个…那一个办法了，还要加强精气的。所以这个地方啊，那么咱们讲这个，这是太阳病，这个少阳病也是一样，阳明病也是一样，全要是这个正邪纷争。咱们讲那个柴胡剂也讲了，血弱气尽，腠理开嘛，邪气因入，与正气相搏，结于胁下。这个打仗地这个，它如果在体表支持不了了，这个正啊，没有胜邪的机会了，它也没那个能力了，这个…这个人的这个…这个…这个，这个身体的这个本…这个本能啊，它始终也不退却。啊，就是奋战到底，它是这样子。它不过是转移阵线，在表不行了，它退到这一个，啊，胸腹腔间，这个干什么？它借用这一切的脏器组织的功能，共同的来把这病邪驱逐除，由呼吸道啊，啊，由泌尿系呀，等等的各方面吧，它利用这些器官，利用肺，利用肾，啊，等等的。它所以把这个病邪呀，啊，他这个正气也往里头来，他在这一块儿来奋斗来。那么里也是啊，它把这个病邪整个包围到胃肠里面，想用这个吐下，啊，这个自然的官能把它解除。他这个，我们好好想一想，在这个机体驱逐疾病只有这么三个，只有这么三个方面，再没有了。这就把这一个，把这个疾病的反应啊，固定到一定的病位上，它不是在表就在里再不半表半里，他没有了。这个人的这个体质啊，是万人皆同。这构造，自然的构造都这样子，所以它自然的就有这么三个方面的这个病…病情反应嘛。这一个病情反应啊，都就全是

在这个人的机能和这个病邪交互作用之下而搞出来的。所以中医这个挺笨的一个事儿，可是他搞这个东西啊，是挺妙，啊。他古人得来也是不简单。所以这个表、里、半表半里是这么样子。没有再没有其它的方面了。那么古人他看到临床上，他也通过很长时间呐，啊…总结出来了，有这么一种三阳病，各有一定的，啊，一定的证候。可是呢，他限于当时的水平，他没…没有其它的可借助的，来理解它。他就是主观想的，啊，这时太阳经络的关系，经络受邪。所以这个东西很耽误事啊。所以现在呢，咱们呢不应该这样子，不足以证明。这个经络是什么？就是血管。你看那《内经》上说不就是血管子嘛。啊，血管受邪旁处都不得病，单这个血…单这个血管，还是…这个血管是单通膀胱的血管，哪有那个事啊！这东西讲不通的东西，他古人没办法，这限于当时的科学水平嘛！哎，他就这么想，这么想，中医的发展是先针灸啊！这也…也可能啊，他利用这个自然的東西，啊，所以针砭石嘛，啊，拿石头磨个尖子他也，啊，招呼脑袋。他这古…他这人这个疾病，威胁人，人老想要对付它。他逐渐的它针灸先发达，由于针灸的这个，啊，这个穴道的关系，啊，他搞出它这么一套规律，这一种规律也客观存在，啊。可是啊，与咱们这个发病是不是它发的病这成了问题了。尤其咱们这一个，啊。所以我们研究这个《伤寒论》我开始就说。你像这个太阳病、阳明病、少阳病这一种三个证候，啊，确实存在，它是客观存在，他古人通过实践发展的，它永远也不会变的。所以现在咱们临床上不常遇着这个事儿嘛，你看看，头几天是太阳病，过两天，他身上也疲倦了，发烧不退，啊，口苦，胸胁满，恶心，这不就是少阳病嘛，这都常见着，古时候是这样子，现在是这样子，未来还是这样子，不会变的。所以这个他是一个自然科学嘛，它是一个自然存在的自然规律，这一个不会变的。所以咱们讲中医有些先生啊，中医不讲阴阳五行，不讲脏腑辨证还有讲…还有东西了？这是瞎说！有东西！你像这个规律它不就是嘛，在这一个规律上来治病

来，现在西医还不会呢，你可知道！这东西挺妙啊！咱们好好研究这个，啊，辨证施治这种精神，很了不起。你看看吧，太阳病，想以汗解不能汗解，咱们就发汗，那正与这个规律相适应啊。所以这个实践里出真知啊，可这一个是没人提！啊，还是散风啊，祛寒呐，啊，等等的还搞这个。但是真正地这个，通过古人这一种的这个…啊，客观事实，我们应该怎么认识它，怎么，啊，把这个理论呐，更提到现实上来。现在大家都不讲这一个。啊，非讲那一套不可，讲那一套，我看将其把中医讲完拉倒。他那套东西不行啊，尤其咱们现在，决不能悖科学而言，这一个是很重要的事儿。科学经过百…百般试验。你在显微镜上，你也瞅着那个病菌了嘛，你还直摇脑袋说没有？人家说是…说是《伤寒论》…说是这个…这个什么伤寒杆菌，给你看，你看看对不对？你说那不是，那是风，那是寒，这是…啊，受了寒了，积久化热。你这东西不行啊。所以这个中医这个问题呀，不是那么太简单，啊。可是这个自然规律是多少年也不变的。所以咱们讲这个三阳，回头你们好好把这个…大家讨论，是吧？研究这个事儿。太阳病、阳明病、少阳病，他的治法，啊，他发病的机制，都可以研究的这个东西。所以这个《伤寒论》这个书啊，真该好好研究。那么他这个书好在哪儿呢？好就好在不是张仲景自己做的。所以这个闭门造车这个东是不对头的。那个皇甫谧说它是论广《汤液》，我认为这个是对的。这个《汤液经》啊，在《汉书》上有的。那么《汤液经》是不是这个伊尹做的？也不是。跟我们那个《内经》也不是，净是黄帝、歧伯呀。他这个中医发展是久…是很久很久的呀。那是，我们是无量数这个医学祖先呐，那集很长的时间呐，通过实践搞出来的。那么，那一个时候他这个…这个书写这个困难呐，咱们那阵儿拿竹板子刻，啊，这还是有字了，啊，那以前更不用说了。所以中医发展相当久，也没人儿知道谁发…谁发…发展出来的，他本来不是一个个人嘛；《内经》也是，也是这个，啊，总结前人的，那么搁到黄帝、歧伯。其…

其实是不是那么个事儿啊？这…这都是，叫我看都是歪曲历史。那全是前人的长时间的…是，啊，反复的总结出来那个东西；《本草》也是，那也不是神农啊，可是后来做书的人呐，我那时候做书也是，你说谁发明的，他也不知道谁，就得找圣人，啊。所以那一个时候也可以说，啊，给这封建势力服务吧，啊。有的圣人…生而知之嘛，如果你要承认这生而知之，那当然是…那…连张仲景那也生而知之，他不是。那个《汤液经》那个书啊，就是记载，就像咱们说这个六经这个，这一种辨证这种，这一种东西，哪个方剂，啊，它是以方剂为主了。张仲景根据那个书，可…可能张仲景这个人呐，他是一个《汤液经》的一个，啊，一个杰出的一个传人。他是有所整理，有所发挥。所以皇甫谧也说，他论广《汤液》为数十卷呐，也没说他就照抄了。但是古人这种结论是从那个书上来的。那么张仲景呢？你看他这个方剂，你就看出来了。你看桂枝加芍药汤，他就说“本云桂枝汤今加芍药”。可是这个加味可能是他。那个本来那个方剂呀，他还是原原本本地搁到那一块儿，他给你注明。全是，非常准，啊。啊…我认为他这个书啊，绝不是他自己，个人没这么大的精力。中医这个东西他是通过实践搞出来的。通过实践，一个人那个寿命才多短呐。那你把这一个，啊，还能把这个病的这一个，啊，这个一般规律都把它搞清楚，还能试验出来某种方剂对某一种具体的这个证治，啊，这么样子百试百效的把它都试验出来，哪能啊？一个人他不可能啊。你就拿这个脉吧，那也不是一个短暂时间你就把…就把它发明出来呀。所以那也经过极长的时间。不过到这一书之前，就这《汤液经》，一…一…那一个问世，中医这一套辨证施治啊，那就是长成了。那当…当然也不是一个人呐，啊，那就是集以前的这个结论。所以中医他是这么样子发展。那么现在最可靠的呢，就是有方法、方式。所以咱们讲这个书啊，也把它摆清楚，今天咱们就这样子，把这个三阳病摆清楚。那么古人他一个看法儿，我们知道他与《内经》不一样，你们回头看看《内经》。

《内经》是这么说的，他说这个六经啊，递传，从太阳传阳明，由阳明传少阳。咱们在临床上就没看着过，啊，阳明传少阳的病，没有；更没有六经治完了回头再传太阳，更没有！所以他不是从《内经》上来的。《内经》还有一点也不是，《内经》说，太阳阳明少阳三阳皆主表，可汗而已。他这个说少阳不可发汗，阳明不可发汗，那他怎么能是，他从…所以这个我们这都是可以讨论。那么他什么方法呢？第一个它是由表及里，由表及半表半里，可能这样子，也有从半表半里再及里。这是他的规律。所以我又把他摆出来，太阳病这么治？可发汗，啊。那么禁吐、禁下、禁温针，是吧？就根据这个书啊。那么阳明病呢？阳明病，啊，实，不只热而且实，那要攻，用承气汤；只是热，尤其外热，我们那一天解释，仲景也说了只能用白虎汤。这都是他的规律方法呀。那么少阳病呢？只能用和解，既不能吐、也不能下、又不能发汗。这就是我们这个，这一种规律呀，始终是这样子啊。那么，怎么来认识这个规律，就是我们方才讨论那套东西。什么叫做阳？什么叫做阴？为什么太阳是表、阳明病是里、少阳病半表半里？那么是不是就是，在表就是叫…就是太阳经络呢？经络受邪呢？这都直接…值得讨论的。古人那一个看法，我们现在离开这个看法行不行？所以这一个都挺重要，啊。研究嘛，我们就得呀，从这一个书，把这个规律，啊，摆出来，我们再通过一个，啊，各人都有思想吧，咱们怎么来认识它，啊，更较比合适，我是这么一个看法。今天咱们就讲到这吧。

辨大阴病^①

注：《宋本》作“辨太阴病脉证并治第十”。

大阴之为病、腹满而吐、食不下、自利益甚、时腹自痛、
若下之、必胸下结硬、（273）

胡希恕：那么太阴病就是里阴证了。也就在里位上，啊，同是在

里位有两种不同的一个证候反应。那么如果“为热为实”，啊，就是热实于里那一个，我们叫做阳明病。那么这一个呢？就是虚寒在里这一个，啊，就叫太阴病。那么，所以开始他讲这个太阴病啊，啊，就是讲这个太阴病的一个提纲了。那就是咱们讲那个太阴病，就是都…啊，这一个提纲都可以概括了。那么太阴病啊，那古人他是辨证他有一定的，病的病形了，啊。那么他是里虚，啊，咱们所说是胃虚停饮呐，所以他腹满。那么胃有水呢？啊，他就要吐。这一个腹满是个虚满，啊。咱们头前儿讲…也讲不少了，所以胃虚呀，这个客热邪气他都往胃这儿来。所以，啊，肚子他就发满；那么里头有停饮呢，他就要吐。“食不下”，啊，咱们现在辨证也常这么说呀，脾虚、有湿，啊，不爱吃东西就是这一种情况。那么他这一个不是只是有饮而已，他由于这个虚呀，有饮，他还不能够收持。啊，收持…自己不能收持。所以，这个自利益甚。这个自利呀，啊，就由于他本身虚，自下利，不是吃药的关系，啊，而且越来越厉害。他是由于胃虚，里头有停水，而且这个胃虚这个机能沉衰到这么个地步，而不能收持它，啊，就是不能…而且这个水在里头还不能够保持住，啊，失去这个收摄作用，所以他自利而益甚。那么这个寒、水，刺激这个胃，胃肠啊，他要疼的。那么如果要是刺激，啊，不那么厉害呢，也有时候不疼，所以“时腹自痛”也是自痛，啊。那么这一类的病，就是虚寒在里，这是“以下为禁”呐，应该用温，啊，用温药来补。如果要以为这个腹满，误为里实，咱们头前儿讲那个胃家实啊，啊，“而下之”，这就坏了，“必胸下结硬”。这个“结”字啊，在这个《玉函经》它是个“痞”，啊。痞硬，啊，与结硬差不多，这倒没有什么关系。一下呀，更使得上边虚了，这个寒、饮更往上冲逆，所以在胸下部啊，更硬满，啊，而为结硬之变。那么，这一段主要的说明这是太阴病的特征，啊。也就说我们在临床上遇着这个虚寒在里，那么反应这一个腹满而吐，食不下，自利腹痛，啊，越来越厉害，这个病就是属于太阴病。这与阳

明病正成一个对子啊，这正是一个相反的，啊。那一个是，啊，热结于里，啊，一派的是一个实热证；那么这一个呢？虚寒在里，一派的是虚寒证。

李冠杰：“辨太阴病”在《康平本》是这一篇的篇名。在《宋本》被改作了“辨太阴病脉证并治第十”。

从这一篇开始，经方理论就开始论述阴性病。在经方理论当中，这个“阴阳”在疾病的类型划分上，指的是人体的机能偏于亢奋或者偏于沉衰。三类阳性病我们都已经学习过了，虽然这三种阳性病之间，它们的疾病属性各有不同，但是在“阴阳”属性上，都属于机能偏于亢奋的阳性证。那么，三类阴性病与阳性病是相对的，就是人体机能偏于沉衰的这一类的疾病。如果站的层面再高一点，三阳病与三阴病虽然分属不同的疾病属性，但是，它们在疾病的性质上，应该是同一个事物的两个方面。都是人体患病以后，在人体机能方面表现出的两个相反方面的不同属性。

在阴性病当中，凡是病证反应属于表证范畴的就属于阴性表证，也就是少阴病或者称之为表阴证。属于里证的，就为阴性里证，也就是我们现在学的太阴病或者称之为里阴证。那么，属于半表半里这一类的，就为阴性的半表半里证或者说厥阴病，或者称之为半表半里的阴性证。

这种划分，对于我们来说，凡是在座的同仁们，都不觉得有什么奇怪的。但是作为整个中医来说，甚至在经方界，这种划分法，也只有胡老的这一套学术理论是明确地把这六类疾病按照这样的属性来划分的。实际上，我们现在这一次学习，主要跟大家分享的经方病理辨证体系，就是在这个基础上产生的。如果没有这个基础的话，我们不至于能够弄出这么一套完整的体系东西出来。实际上这一套体系没有什么新的内容，只是把各种类型疾病之间的关系和不同属性疾病之间的关系理顺了。就说表阴证，关于表阴证，这是胡老首次提出来的。

也就是说，在将近两千年的整个经方的历史里边，只有胡老明确地把它提出来了——少阴病就是阴性的表证。这一篇太阴病，就是整个阴性病里边的里证。

这一类疾病的基本特征：就是人体机能偏于沉衰。所以在这一类疾病当中，绝大多数的方证，都有虚寒的性质。所以，在经方辨证里边，常常把里阴证，统称为里虚寒证。但是，我们在今天学习当中就得澄清这么一个问题。实际上这种说法只是说对了绝大多数的方证。对于阴性的里寒证同时又有实证的，它的数量确实不多，实际上就是忽视了。因此对这个问题我们需要澄清的。

这个条文在《康平本》是顶格排版的条文。

“腹满而吐”，这儿的“腹满”在病理上，实际是人体胃肠功能功能偏于沉衰，对于饮食入胃的食物，消化吸收能力下降所致。正常情况下，我们吃进去的东西，只要吃到胃里边，消化过程就已经开始了。如果胃肠的功能偏于低下，甚至于沉衰，那么整个的消化过程就会减缓，或者吸收功能变得非常的微弱。这个时候，实际上就形成了一种病态，这就成了病了。轻的时候，就会食欲下降，吃得也少，就不愿意吃；重了的话，就会感觉“腹满”，甚至会出现“呕吐”的情况。实际上，应该是人体一种本能的反应。但是，表现出来的这种症状，跟机能偏于亢奋的阳性证，有时候也会表现一样。里实证因为里边机能过于亢奋，把水分都蒸发掉了，也会造成食物积滞在里边，也不消化吸收了。也会出现“食不下”，“腹满”。这儿就需要加以鉴别。

“食不下”与“腹满而吐”，实际上是相同性质的问题，都是胃肠功能沉衰的症状反应。食物不能正常吸收，所以就不想吃东西。整个消化功能紊乱了，吃到胃里边的东西，正常四个小时就能消化完的，结果现在八个小时也没消化完，这个时候怎么可能再吃呢？人本能的一种反应，就不能吃东西了，“食不下”。

“自利益甚”，就是在没有明显外因的情况下，发生下利，就是腹泻。而且，这个下利的程度还会不断地加重。这种下利在病理上，实际都是一样的。也是胃肠功能偏于沉衰，对肠道内的食物，不能充分地消化吸收。还没有来得及消化的东西，就排下去了。所以，这种症状在临床当中常会伴有“完谷不化”，大便里边带有没有消化的食物，有这类的情况。

“时腹自痛”，这是由于里寒引起的一种腹痛的症状。这个腹痛，是由多种原因引起的，后面还有一个桂枝加芍药汤证，跟这个又不一样。

那么，所谓的里寒证，我们其实前面已经讨论过，那个时候主要集中在讨论里热证。里寒证跟里热证是相反的，就是人体内脏由于机能偏于沉衰，而呈现出来的一种体内环境温度偏低的症状，就是这么一种状态。咱们临床当中观察，凡是有这类病理状态的患者，自我感觉常常是喜热饮、怕冷食，喜欢用热水袋或者是什么的暖一暖腹部，感觉到非常舒服。而且，给他做腹诊的话，常见这个腹部的皮表温度就偏低，可想而知他体内的温度肯定也会低了。常常是吃点凉东西，就会出现腹泻或者不适。

从这儿我们能看出来，所谓的里寒，就是体内温度低于正常值。原因就是人体的机能沉衰，导致体内各种代谢减慢、能量减少而体内温度下降。当人体处在这种病理状态下，必然会出现一个很重要的问题：就是循环系统的机能下降。

有了这个因素，就会导致人体的组织器官所得到的能量分配，比正常的能量分配要少。实际上，这个“时腹自痛”，这种因里寒证引起的疼痛，跟人体出现四肢厥逆道理是一样的。但是，具体表现的部位不一样。四肢厥逆，是四肢，人体的远心端，它获得的能量尤其少。这个里寒证，跟它的部位不一样，发病机理是一样的。它呢，是集中在腹部这个地方能量不足，产生的热量也不足，就表现为一派寒象。

当这些组织的能量水平低到一定程度的时候，就会出现疼痛感。这种疼痛感，实际上是人体自救的一种本能。实际上这种疼痛，给人体一种不正常的信号。人体就认为这个系统里边缺乏营养，就会往这个系统里边调集能量。实际上，人体在很多情况下的疼痛，都带有这种属性，就是两面性。疼痛本身确实说明有某种程度的病变，但是，本身也是一个自我修复的过程。

这儿“腹满时痛”，也是带有这种性质。当内脏的组织器官能量水平低到一定程度的时候，就表现为一种疼痛。如果能量有所恢复，这个疼痛还能缓解。这就出现了阵发性的疼痛，“时痛”嘛。

这个条文论述的，是真正的太阴病。也就是阴性、里虚寒证。

我们在这儿也跟大家提个醒，实证没有包括在里边。不一定作者没有这方面的意识，而是想论述清楚，是一个很复杂的问题。所以这儿，不包括阴性的里实寒证。

那么，实际在临床当中，除了这个条文里边的述症之外，还会有许多阴性里虚寒的一些证候存在。比如：精神不佳、但欲寐、或者喜温怕冷、脉沉迟或者微弱，或舌淡苔白这一类的。总是有一派的寒象、一派的虚象。

再接下来，“若下之，必胸下结硬”，虽然文字不多，一方面阐明了太阴病的治疗禁忌。实际上治疗禁忌，也是治疗原则相当重要的部分。另一方面，以“胸下结硬”具体的症状为例子，阐述了太阴病“误下”后，可能出现的不良后果。

刚才，我们说了太阴病是机能偏于沉衰的里寒证。然而这种胃肠功能低下所表现出来的症状，有时候，跟机能偏于亢奋的里实证会很相似。比如“腹满、食不下、腹痛”，在阳明里实热证里边，也常会见到。但是，太阴病只能用“温补”的方法来治疗，这就跟阳性里实热证正好相反。如果临床当中你要是误将这一类的疾病辨为实热证而用“下法”，那就可能造成严重的不良后果。

这儿虽然仅仅是例举了一个“胸下结硬”，但是，足以说明人体已经发生了胸胁部位内脏器官的严重病变，这都是一些比较严重的病。当然，临床当中太阴病误下以后，绝对不会仅仅表现为这么一种变证。但是，对于太阴病误下的严重性，通过这个症状就已经论述得非常清楚了。

在这一篇里边，这是唯一一条顶格条文论述太阴病的条文。虽然文字不多，但论述的内容还是比较全面的。既有太阴病的提纲，即对太阴病的界定；又有太阴病的治疗禁忌——治疗原则；同时还阐明了太阴病误治以后常见的不良后果。

做个小结：太阴病，常表现为腹满而吐、食不下、自利益甚、时腹自痛等症状，如果误施下法，则可能出现胸下结硬之类的严重变证。

大阴中风、四肢烦疼、脉^①阳微阴涩而长者、为欲愈、（274）

注：《宋本》无“脉”字。

胡希恕：“太阴中风”啊，这就是，暗示就是由太阳转属为太阴病，啊，他所以说个“太阴中风”，就是太阳病中风证，那么传里而为太阴。这一个，这个太阳病本来是个有余，啊，他是一个阳性证啊。太阳病传里以传阳明为常，但是也兼有传为太阴的，也有，少。那么这个少阴病传里呀，大概都传太阴，但是也有少的时候，啊，而传阳明的，啊。这个，所以这一段呐，他指着太阳中风证，啊，传里而为太阴病。“四肢烦疼”，这是太阳病的证候啊，是吧？那么这说明这个太阳中风证，啊，在表未已的一个证候。“阳微阴涩而长者”，这个脉呀，阳微者，浮见微。这个太阳病，浮而见微者，这个外邪已衰之象。脉虽然还浮，但微的很了，啊，这说在表之邪也衰了。“阴涩”，啊，这是里虚呀，咱们…涩者为血少嘛。他由于转属太阴下利，那么丧失津液，啊，所以这个阴涩。虽然阴涩是由于…啊，转属太阴而有

虚之象，但是脉不短而长，说明这个胃有恢复的一个倾向。这个水谷啊，是来自于胃。那么如果这个脉短呢？这个津液是虚竭之甚了，啊。所以咱们头前儿讲阳明病里有“脉短者死”啊，啊，这讲这个津液虚的时候，但是脉长，说明这个胃气恢复，那么虽然涩是虚了，但是，啊，看这个脉长啊，这是有“欲愈”的一个征…一个征兆。表邪既微，啊，而里气欲复，所以“为欲愈”。这一节儿说这个太阴病……这一节来这儿搁着呀，不怎么好，他这一…这一…这一篇书里头他意思很多，咱们讲完再说，啊

李冠杰：这条在《康平本》是降两字格排版的条文。

“脉阳微阴涩而长者”在《宋本》里没有“脉”字，是“阳微阴涩而长者”。

解读一下：

“太阴中风”，“太阴”可以理解成患者有太阴病提纲中近似的症状，或简单地说，就是指的有里虚寒性的下利。“中风”从它的述症看，是同时有表虚证的症状反应。

“四肢烦疼”，在这儿属于表证的症状。

“脉阳微阴涩而长”，是指的脉浮取微弱、沉取既涩又长的一种脉象，涩就是不流利了。脉诊在中医里是一门非常重要的学问，有它的规律性。通过这一次的学习，大家可能对脉诊都会有比较客观的认识，脉象与其他的症状反应不一样的地方是它的客观性，不受病人主观感觉的影响；一样的地方是它有不稳定性，不是某种脉象一定是候某种病理。“阳脉微”虽然有“四肢烦痛”的表证的症状表现，但是表证的病势已经缓了，因为表证一般表现为浮脉，浮象已经不明显了，很微弱了，说明表证的病势已经比较缓了；沉取现涩脉，候精血虚少。这个脉象与述症这种表里俱虚的病理是吻合的，但其中的长脉是一种有余的脉，说明患者已经有了自我恢复的趋势。

所以说“为欲愈”，这是人体向愈的一种证候。

在临床中，这种以脉来判断疾病发展趋势的办法，有一定的实用价值，你如果经验比较丰富，它确实能起到判断的价值。上次说过，有时候人好好的，要是摸着有不正常的脉，得把其他的因素剔除出去，确实没有其他的因素，他真的有可能病情会加重或者会闹病，有这类的情况。有的人感冒了，吃了几天药感觉还没全好，医生一把脉，说不用再吃药了，病到好的时候了，有时候也有这种情况。实际跟这儿说的是一个意思，但是不能机械地套用。

我说一种比较特殊的情况。我碰到过一个很重的病人，卧床好几天不省人事，呼吸急促，就等着咽最后这口气了，脉始终是典型的病脉，洪大而且跳两次停一次，很不正常。但是到最后真要咽气的时候，病人反倒是表现出平脉，基本上就是正常的脉了。一把到这种脉，我说不行了，赶紧准备，一会就咽气了。具体情况要具体看待。

大阴病、欲解时、从亥至丑上、（275）

胡希恕：这都信不得的，这个头前儿跟太阳病“从巳至未上”，啊，阳明病“从申至酉上”（应该为“从申至戌上”，胡老口误），这个东西都要不得的，啊。这是古人根据这一个，啊…这是五行的一种推算的法子，啊，不一定准确的，啊。啊…这一个，啊，不可随便信，没什么大意思。它是照例的文字，啊。因为太阴是至寒了，至阴了，所以这一个，他这个旺时啊，在亥至丑。所以他这个书都是…都是在旺时的时候这个病好，这根据五行的看法，这一个不可靠。

李冠杰：这条在《康平本》是降两字格排版的条文。

像这种条文，六大类疾病里边都有，都一样的，没有什么实际意义。

大阴病、脉浮者、少^①可发汗宜桂枝汤、^②（276）自利不渴者、属大阴、其脏有寒故也^③、当温之、（注）宜服回逆辈·（277）

注：

1. 《宋本》无“少”字。
2. 《宋本》此处有桂枝汤方及方后注，此从略。
3. “其脏有寒故也”《宋本》作“以其脏有寒故也”。

胡希恕：276 这一段呐，啊，其实不是太阴病，啊。他冲着下利说的。这个下利这一类的，啊，虽形似太阴病，但是它不是的，就是一般的下利。这跟我们头前儿讲的那一个，太阳阳明合病，必下利，用葛根汤主之是一个问题。那么为什么这个搁个太阴病？他这两…两条儿你要对照看就好了，有虚实之分，“虚实”在表证不在里证。那么真正太阴病啊，虽有表证也不能够发汗，啊。咱们头前儿讲很多了。所以“下利清谷”，那么这一种虚寒，像咱们上面提纲这个样子，那只能救里不能解表。那么这一个都冲着下利说的，啊。这个下利病要是脉浮，有太阳病的证候，如果实，你可以用葛根汤，就是麻黄剂了，发汗，啊；那么如果是虚，它桂枝…显的…显现的是桂枝汤证，这一个当然是脉浮弱，啊，那一个是脉浮紧了，从脉上来说。那么就从证候上来说呢，那么那一个一定是无汗，这一个可能是有汗，啊，他用的是桂枝汤啊，是吧？所以我们在临床上啊，这很有用，啊。但是这一段搁到这个地方，他是另有旁的意思，啊。以后我们再解释。那么主要在临床上这是很有用的。这个无论是腹泻无论是痢疾，这一个都讲的是痢疾呀，大概都是痢疾呀，啊。这一种痢疾…这一种，啊，这个病…如果他显现是表证，就说明这个病啊还是有表解，有表解之机呀。那么这个时候抓紧时，啊，时机而用发汗药，十有八九要好的，这一个咱们要注意，啊。这天儿，啊，这痢疾快…快有了，是吧？那么这一个，这在西医呀，不可理解，说是用发汗药还能治痢疾？啊，

不是发汗药治痢疾，因为痢疾呀，他以…他这个证候以太阳病反应出来了，那我们就要用发汗的法子；没有表证，那你千万不要发汗，啊，那是不行的。那么这一段呢，他是冲葛根汤证那一条儿说的。那一个他是，说“太阳阳明合病”，那么这一个偏虚，他说一个“太阳太阴合病”的意思，啊。他所以搁个“太阴病，脉浮者，可发汗，宜桂枝汤”那么这个治疗的手段呢，跟那葛根汤是一个…啊，是一致的。后来少阴病也有，那么少阴病下利，他用的是白通汤。这个白通汤啊，也是个发汗药。它是…以这个大葱为君呐，这个…这个方剂呀。葱白他用十四茎，那么里头搁干姜，啊，与附子。这个阴证，你非用温性药，亢…亢奋温性药不可的。他现于脉微细，啊，这一类的下利证，他要有表证，那你用葛根汤不行，用桂枝汤也不行，那非用白通汤不可。所以这在后头有，啊。那么这几条啊，意思都是一样的。虽然下利这是病属里呀，但是他反应以表证反应出来，我们还要根据这个…适应这个表证而应用发汗剂，就可以好病的，啊。要没有表证是不行的，啊。所以他这个书啊，啊…他古人这个…这个词句呀，所以咱们对他这书的认识应该掌握他这规律。不要认为他这一个，啊，词句之间，那…那就是坏了。说这一个是太阴病，那一个是阳明，啊，太阳阳明合病，其实一个…其实一样儿。就是所现的证不同，所用的方剂也就是不一样。

277 条儿，“自利不渴者，属太阴，以其脏有寒故也，当温之，宜服四逆辈。”这一个，这是最重要。这一段它呼应到头一节儿了。太阴病这个下利呀，不是咱们一般所说那个样子，啊。“不渴”，所以自下利而不渴。这个渴与不渴是我们辨寒热的一个主要的一个证候。这个在临床上，啊，咱们也是常遭遇呀，那么这个人说口干、口渴，那么他肯定里有热，那不是太阴，是吧？所以自下利，口中和，这个三阴病都口中和，啊。那么，我们看他也是没舌苔，啊，这口中啊，挺滋润，而不渴。这一种自下利，这属于太阴。那么为什么他不

渴呢？“以其脏有寒故也”，这里头是有，啊，因为里虚有寒，所以他不渴，他没有热。那么这一个只能够温，“当温之”。用什么药呢？

“宜服四逆辈”。这个四逆辈呀，概括很多了。你像咱们说理中汤，啊，四逆汤，通脉四逆等等的吧，啊，你像附子汤啊，这通是，啊，真武汤。我们用什么呢？因证而施啊。所以仲景这个书啊，他注重在最后是方证。他通过六经，啊，六个类型，然后他要分析寒热虚实，啊，又分析八纲，那么最后这个具体证治，通过六经八纲还得辨到这个方剂上，啊，所以他搁个四逆辈。这就是让你临床上啊，啊，具体分析，该用理中用理中，该用附子汤用附子汤，该用四逆汤用四逆汤，啊。所以我们对这个方剂的适应证，必须要搞清楚。那么这一段看出来这个太阴病，他这个自下利，纯粹是里虚有寒呐；否则那不是属于太阴病，啊。那么真里虚有寒，那只有温之一法。

李冠杰：这两个条文都是降一字格条文。

“太阴病，脉浮者，少可发汗，宜桂枝汤”，这是第 276 条；下边是第 277 条：“自利不渴者，属太阴，其脏有寒故也，当温之”。最后有一个附注：“宜服四逆辈”。

那么，“少可发汗，宜桂枝汤”在《宋本》没有“少”字。另外，《宋本》在第 276 条之后，有桂枝汤方和方后注，《康平本》没有。“其脏有寒故也”在《宋本》是“以其脏有寒故也”。

下边，解读一下条文：

“太阴病”，实际上在这儿指的就是“下利”而言。我们看方剂就知道，这不是一个真正的太阴病那种下利。这儿为什么用“太阴病”呢？你只能这么理解，其表现有跟太阴病提纲里边所述症比较近似的症状反应。但是，在病理上跟真正的太阴病有质的区别。这个条文论述的是一种什么情况？实际上是一种在表虚证的同时又伴有略偏于里虚寒的下利这么一种情况。为什么说略偏于里虚寒？它肯定不是一个热性的下利，但是，偏于里虚寒也偏得不是多么重。为什么？因为

如果跟桂枝人参汤证相比的话，还没有桂枝人参汤证的寒性那么大，就是里虚寒没有那么严重。这儿，实际上是以表证为主，虽然有下利的症状，但是，虚寒的证候不是特别的严重，这也是人体患病的一种比较特殊的情况。虽然有下利，但是，还是以表虚证为主要的证候。

“脉浮者”，就非常明确，用脉象来说明什么呀？来说明这个时候应该是以表证为主要的病理基础。因为脉象，这仅仅是浮脉。因为这个作者也是比较偏重于用脉象来解释病理的。这个地方他就明确地想用这个脉象来说真正里证的证候不明显，虽然有下利。同时，他在这儿也等于说出了另一个问题，这个患者肯定有非常明显的桂枝汤证，也就是表虚证的证候：像汗出、恶风，明显得有。这只是用了一个脉浮。因为后面有方剂。

接下来是“少可发汗，宜桂枝汤”。这个地方的论述，非常得精而且细。但是在《宋本》却把这个“少”字遗漏了，少了这个字，确实对原本意的表达，大打折扣了。这就使这个条文变成什么了？与单纯的太阳表虚证，以桂枝汤来发汗治疗，没有任何区别了。事实上这个时候，人体一方面有表虚证，还可能会有汗出；另一方面，还有里虚证，而且下利，这就会进一步地加重人体津液损失。这个时候，即便是用桂枝汤来发汗治疗，那么发汗也要较正常发汗为轻。这个“轻”，大家可能要问：再怎么轻啊？本来桂枝汤发汗，就是微似有汗。这个“少”在这儿，好像确实没什么意思。为什么这么说呢？其实真正的桂枝汤证，给他服了桂枝汤，再让他喝点热的粥也好，热奶也好，再盖的厚一点，如果这个人出汗多一些，不是微似有汗，当然也到不了大汗淋漓那种程度，他可能病仍然能好，但是他会觉得比较疲劳。但是现在这种情况你要这么治疗，很可能就危险了，就不一定能好。

因为我有这个经验，一次有一个人感冒，他是什么情况下服的呢？洗了澡以后。本来就洗了热水澡，汗出的那种机制都激发出来了，

然后他又喝了桂枝汤。他说：“哎哟，昨天晚上我出了一身大汗，今天感冒症状没有了，但是觉得挺累”，就是这种情况。如果这种情况，要赶到有下利的情况，那肯定就不好了。所以你要这么来理解，这个“少”字，作者用得非常得精道，论述得很有分寸。但是，到了《宋本》给去了。

那么这个条文，实际就是桂枝汤证。我们用很通俗的话来总结一下，桂枝汤也有治疗下利的机会，那得以桂枝汤证为主。对这种下利，就要做具体地分析：这个下利，既不同于桂枝人参汤证的里虚寒证比较重的下利，在虚寒的程度上不一样；也不同于“桂枝加芍药汤证”，因为血虚所造成的下利；更没有太阴病的那种阴性证。所以，在临床表现当中，既不会有明显的腹痛症状，也不会有严重的腹满食不下等等这一类的。许多在其他方证里面的症状，在这里面是没有的。

那么这个条文，论述的是以桂枝汤证为主，同时伴有里虚偏于寒性下利的这种情况。

如果，我们以这个方证为切入点，把经方理论当中有关这一类的，像表里同病，里证又是以下利为基本特征的这一类的方证，联系起来解读，我们就可以从中更好地理解经方病理辨证的精髓。

把相关的方证列举一下：

桂枝汤对应的下利是什么？是以表虚证为主，同时伴有偏于里虚又微偏于寒性的这么一种下利。

如果在这个基础上，里虚寒的程度加重，就成了以里虚寒为主要矛盾的桂枝人参汤证。经方治疗有一个原则：凡是表证和里证同病，里证属于里虚寒的，要先救其里，然后再解表。或者表和里同时治疗。桂枝人参汤证就是一个表里同治的例子。

如果下利偏于里热证的，就是桂枝加葛根汤证，比桂枝汤证的下利就偏于热了。因为葛根是一个寒性药。

如果表证偏于表实证的，就是葛根汤证。这个也是下利而且有一

点偏热，但是表证是趋于一个实证。

如果下利偏于血虚的，就是桂枝加芍药汤证。

如果下利不单单是虚寒性的，而且整个人体也陷于机能沉衰的阴性证。那就是白通汤证。

这些方证，虽然都属于表里同病，但是，不单单存在病理上的差别，而且相同的病理方证当中，还存在着一个程度上的差异。所有这些差异的根本，还是一个症状反应上的不同。当我们理清了这么一条线，在临床当中，如果能把这种分寸把握住，先是能把这个疾病的类型性质分清了，然后在相同疾病性质里边，再去分一分程度的不同，这不仅意味着你用方可以用得对，而且合方，加减也有依据。辨证到家不到家？就在这些方面看你能不能把握得好。

实际上经方医学，就涵盖了这一类——表里同病的这一类。当然我们仅仅是举个例子，就涵盖了这一类疾病几乎所有的典型的疾病的表现形式。如果我们再把合方、加减等因素考虑在内的话，凡是这一类的疾病，没有不在经方治疗范围之内的。问题的关键在哪呢？在于辨证准确与否！

比如：桂枝汤证的下利和桂枝人参汤证的下利，就是一个里虚寒的程度上的差异；

桂枝加葛根汤证的下利和葛根汤证的下利，都有一点偏热，是表证虚实之差异；

桂枝加葛根汤证的下利和桂枝汤证的下利，又是一个寒热之差；桂枝汤证的下利和白通汤证的下利，就是阴性证与阳性证的差别了。

如果这样展开的话，这是一个既宽泛又细致的整个的一个疾病谱。所有类似的疾病，既有表证又有下利为基本特征的这么一类的疾病，实际上都包括在里边啦。

下边是第 277 条部分：“自利不渴者，属太阴，其脏有寒故也，

当温之，宜服四逆辈”。在《康平本》这段条文和上一段条文是同一个段落的内容。所以，在内容上是相互关联的。到了《宋本》给断成两段，这种关联性就淡化了。

“自利不渴者”，这儿的“自利”有两方面的含义：第一就是指的以下利为主的症状反应。上一条的“太阴病”，就是指下利而言。第二层意思，在这儿论述的是以下利为主，表证为次，或者没有表证的这么一类情况。那么“不渴”，是里虚寒证的一个比较重要的特征性的症状。里虚寒证就是内脏的机能偏于低下，整个的代谢过程也趋于缓慢，容易出现体液积滞这一类的情况。所以，很少表现为口渴。

“属太阴”，实际上是条文的作者，将“自利不渴”这种症状反应界定为太阴病的范畴，这也是太阴病的一种。

“其脏有寒故也”，这儿就进一步地阐明太阴病的病理是：里虚寒证。并且，也论述了相应的治疗原则，就是“当温之”。

从这段条文的述症看，条文所论述的，实际上是典型的桂枝人参汤证，后面呢，可能偏于理中汤证，就是这么一种情况。

但是，条文最后加的附注“宜四逆辈”，就是上边这一类的情况，适宜用四逆汤来治疗。这就出问题啦。它混淆了桂枝人参汤证、理中汤证这一类的方证与四逆汤证之间的区别。这个“自利不渴，属太阴”，实际上，是在第 276 条的基础上，又出现了“自利不渴”这一类的，他论述的就是这一类的情况。如果，这个地方需要用四逆汤之类的方剂来治疗的话，那么第 276 条所论述的，就不能仅仅用桂枝汤来治疗，因为它有阴性证，至少也得用桂枝加附子汤这一类的方剂来治疗。实际上加的附注不够准确。没有真正理解条文的真实意思。

做个小结：太阴病如果表现为脉浮的，可以用少发汗的方法治疗，适宜用桂枝汤；若自利不渴的，属于太阴病，这是因为内脏有寒证的缘故，应该用温里的方法治疗。

伤寒脉浮而缓、手足自温者、系在太阴、当发身黄^①、
若小便自利者、不能发黄、□□□□^②至七八日、虽暴烦，
下利日十余行、必自止、（注）以脾家实·腐秽当去故也·（278）

注：

1. “当发身黄”《宋本》作“太阴当发身黄”。

2. 《宋本》无此四个缺字符号。

胡希恕：这一段很重要。他在阳明病啊，就提过。那么这一个，这个里证之所以发生啊，他…咱们这一个…这个，啊，他这个前后都是这样…一贯。咱们这个…这个证候的反应啊，在…啊，古人看呐，它不是一个疾病自己在那儿起作用，它是疾病和我们这个人体的这个，啊，这个抗御疾病这个机制啊，是交互作用下的一种反应。咱们头前儿也讲了，是吧？在太阳病，啊，这是这个正邪交争于骨肉，在体表，意思呢？要达到发汗目的。这《内经》说的很详细了。你们回头可以自己找一找，在这个《素问》，啊，评热病论就有这一段，阴阳交那一节儿。我上次也说一回。他说，人之所以汗出者，皆生于谷，谷生于精，夫邪气交争于骨肉，啊，而得汗出者，精胜也。精胜当不复热…当能食而不复热。他那一段说的很好，那就说这个正邪，在这个，咱们说太阳病这个阶段呐，他就是相争在体表。那么达到发汗呢，他就好了，达不到呢，就显出来太阳病这个证候了，所以“脉浮，头项强痛而恶寒”。咱们讲这个半表半里，讲这个少阳病的时候，也讲过。他这个少阳病啊，也是咱们这个机体主动的，它要改换这个策略啊。他因为在体表，他不足以祛邪了。所以这个人身上这个，咱们说这个正气了，就我们这个，啊，咱们这医书都说正气了，老与邪…它是斗争的，啊，一息不存。那要…他要是不斗了，人就完了。所以在半表半里上也是，表不足以祛邪了它退到里头。退到哪儿去了？所以结于胁下呢。外表是血弱气尽了，他打算由半表半里，半表半里什

么地方？就是我们一切脏腑所在之地，就是胸腹腔间。它利用呼吸系统，泌尿系统，排泄系统，这些脏器的官能，协同把这个病要打算从这一… 这一部分排除。要排出去也就没问题了，要解除啊。没解除就形成少阳病那一种“口苦，咽干，目眩”的那一种证候。那么这个里证呢？也是一样。那么无论是在表或者半表半里，不足以祛邪，他就把这个病啊，尽量这个，啊，包围到这个胃肠里面，也想由胃肠里面，啊，或者涌吐，或者泻下，把病去除。那么这一段呢，你看看这个，啊，所以在阳明病他也提出来了。这个伤寒脉呀，他本来浮紧。太阳伤寒嘛，这头前儿都讲过的东西了。那么这一个它“浮而缓”，“浮而缓”说明什么了呢？津液不充于外了，这个伤寒他是没有汗呐，没有汗这个脉应该紧，这个外表啊，充斥津液，啊。他退到里头去了，这跟那个“血弱气尽”是一样的，它往里头来了，他这脉就缓了。那么再往里头之后了，它不但缓，它还要沉了，啊，沉实嘛，它整个进里头去了。那么这一段，他是脉已经“浮而缓”，这个气不充于外了，有内传之势了。内传要传阳明呢，他不光手足温呐，他是一身手足俱热呀，那是真正阳明病，啊。所以咱们头前儿有嘛，“身热汗自出”，是吧？真正传阳明了。他只是手足温，那么说明这里面呐，不够那个阳明病那个证候，他所以说个“系在太阴”。还有虚寒的这一方面，啊，与太阴有联系。这一个说明什么？我们讲阳明病讲过了，这阳明这是里热呀，那对人身上的水分蒸发非常的快，小便数，汗自出。那么他这个时候他“系在太阴”呐，就说这一个将“脉浮缓”，而没到那一个程度呢，里头恐怕还是有湿呢。没到“大便结硬”那个程度。那么这一个时候常常发生“发黄”。如果里边湿，这个热可是在里头有了，要是热瘀于湿，那就要发黄。他说，太阴者当发身黄。这古人的一种看法。其实我们遇着这个太阳伤寒，要是脉浮缓手足温呐，也有的时候这一种证候，就是发黄一个先驱证。拿咱们现在话说，啊，就是这个急性黄疸性肝炎，他有这个先驱证。那么也有不是的，这个

病将传里他是里头在蕴热这个，这个阶段，也有这一情况，啊。所以古人把这个他拿出来呀，啊，一并说，说这个时候啊，有几种情况：一种情况可以发黄；另一种情况呢？小便自利，说明这个热还是盛，这个湿往外跑啊，啊。湿由…湿越于外，光热他不会发黄的。咱们在阳明篇他说一个大便硬者，七八日，大便硬者属阳明也，那就真正…就是变成阳明病了。这一个他没讲那一段，这个他说个什么，“至七八日，虽暴烦下利日十余行，必自止”，这一个，啊，他在这儿他就是变化了。因为这一个病啊，有三种的情况的这个结果：一种他如果这个真正这个邪都…啊，进于里…而为热结于里的时候，汗出小便数，大便一定硬，那就变成阳明病；第二个，那么在这一情况啊，也常使着这个湿…瘀…热瘀于湿而为发黄，啊；第三个，就像我方才讲这个，啊。他也没大便硬，这个时候他暴烦下利，这个病也就好了。这就是我们说这个，这一个病之所以为里证，这个生理呀，就要达到这个目的。如果这个胃…啊…没…没…不是虚，这胃气相当强，而且达到祛邪的目的，他下利。“虽暴烦下利日十余行”，这一个，这个病是一定要好的。什么道理？这是脾气不虚。脾不虚，就是究其实还是胃了。这个他讲的太阴病啊。那么这个阳明病，它就是这个人身上这个…咱们说这抗病这种机制啊，这是个良能啊。这个良能不是一个万能。常常的把这个病啊，啊，包围到胃肠里面了，达不到这一个自愈的目的，反而大便不通，这是一种，那就变成阳明病；可是虽然大便通了，这个脏器虚衰，他达不到驱除疾病的目的，而本身都病了，那就是所谓太阴病；那么如果，啊，脏器也不衰，也达到下利了，这个病一定好。这就是这么一个问题，所以这一段相当重要。他这是谈病理的问题，啊。为什么他老搁这儿呢，在阳明篇他也讲，他讲的是阳明病，他没讲到自愈的这一方面，啊。他说如果不发黄，小便自利，啊，这一个内在的水份都没有了，他光有热了就变成阳明病了，所以大便硬者属阳明病也。那么这一段呢？他讲的太阴病。太阴病啊，如

果像这个头条这个提纲，那就是脏器虚衰了，虽然下利不足以祛邪。那么假若脏器不衰而下利了，那正是这个机体的达到了目的了，就是正胜了邪去了，他这一段主要是这个。所以他前后的这个…啊，他稍稍变化变化，他这个意思啊，充分到这儿算发挥了。在阳明病到这一个地方，啊，他整个就把这一段的意义发挥到了，啊，完备。那么再一个就说，你不能看着“腹痛下利”全是太阴病了，是吧？那么，这一段正 是大相反，啊。这是病愈的一种反应了。

李冠杰：“当发身黄”，在《宋本》里边为“太阴当发身黄”，多了两个字；还有《宋本》里边没有这四个缺字符号，这又能证明《康平本》的真实性。

这是一个降一字格排版的条文。

下边解读一下：

“至七八日”之前的内容，在阳明篇的第 187 条当中已经出现过，这两条的相关内容（不是所有内容）几乎完全相同，论述的是相同的问题。这个条文是降一字格排版的，但是第 187 条却是一个降两字格排版的条文，实际上这倒合理啦，如果出自同一个作者之手的话，他不会做这种重复的论述，这说明第 187 条的内容是降两字格排版的这个作者，也就说王叔和从这个条文里面摘录过去的，原因很可能是根据他的理解，他认为这一类的情况也有发展为阳明病的可能。这不是凭空捏造的，咱们仔细分析就知道了，这一条也不是太阴病，而是有热，咱们可以一点一点地看。所以他把这一段内容给摘出来，移到 187 条那个地方去了。

这一条论述的实际是外有表实证，里有湿热证的一种病理状态。

“伤寒，脉浮而缓”，这是指啊，患者没有汗，就说是一个表实证嘛，可能也会存在某些表证的症状反应，所以说“伤寒”，包括后边的“脉浮”。既然有表证又没有汗出，本来应该现浮紧脉，但是这儿出现了“脉浮而缓”。这是由于同时还伴有里有停饮所致的，咱们看一看就

清楚了。

“手足自温”，本身就是里热证的一个症状反应，有里热。

“系在太阴”，《宋本》是“是为系在太阴”，这个没有质的差别。“系在太阴”，它是指疾病发于脾脏，你只有这种解释，才最合乎它的本意。在学习第 187 条的时候，我们就是这么解释的。这的“太阴”，是借用的《内经》里边对经络命名的足太阴脾经的论述。

“身当发黄”，就是一个最好的说明。在经方理论里边，凡是黄疸，多为湿热所致。而这个条文的述症也有湿热证。可是经方里边，特别是顶格条文论述的那种黄疸，从来没有论述说是某一个脏腑器官，与某一个脏腑器官有关的。里有热又有停饮非常明显，如果在脏腑辨证的理论体系里边当中，他就认为由于是脾脏被湿热所困，造成这种黄疸，并且认为发生这个黄疸，是因为脾属土，土色发黄，黄疸就是这么来的。这儿的“系在太阴”，就是从这个理论基础上而出现的这么一个论述、论断。但是这种理论，对于像抵当汤的那个黄疸，硝石矾石散这一类的黄疸，麻黄连轺赤小豆汤这种方证所出现的黄疸，就没法解释了，而且它也解释不了。所以它跟经方理论不是一个体系。

从这儿我们可以看出来，通过具体的病变部位来认识疾病的这种思维方式，始终在人类医学当中占着主导地位。主导到什么程度？我们经方理论的传承，就是一个最好的说明。这次我们是以《康平本》为底本来学习的，咱们在学习当中，能够清楚地看出这一点，尽管在顶格排版条文全部的论述内容当中，对于以具体的脏腑器官和病变部位这一类的实质性论述，几乎等于零。有没有涉及到脏腑的这一类的论述？有。比如阳明病“胃家实”，就明确提出一个胃嘛，但是那个“胃”是一个抽象的，你很明显地能感觉出，能体悟到。

但是后世的注家，包括顶格条文作者之外的所有的作者，都在有意识地夸大这些。在顶格条文里边，仅仅能看到的那么一点点的脏腑

经络方面的一些元素，就有意识的去夸大。这个条文就是一个很明显的例子。以至于到最后，把经方理论发展成了一个以脏腑辨证为核心的一套医学辨证体系，就成了一套体系了。除了胡希恕学术思想之外，你随便翻开哪个人的伤寒注家的体系看一看，离开脏腑经络解释的，凤毛麟角，非常非常得少。

我们学《康平本》，你就会非常明确地感觉到，人家顶格条文作者压根就没这个意思。我常说这句话，一个医学巨著，而且是整个中医界公认的一个经典，四大经典之二的这么两本书，它的真正的作者几乎只字未提脏腑，没有一点实质性的论述，这不是一个偶然的问题。如果想说的话，他不会写肝字吗？不会写脾字吗？不会写胃字吗？不会写肠字吗？还有比那种论述再明确的吗？再好理解的吗？为什么他偏偏要绕开它呢？都是有用意的。这也就是到目前为止，整个中医界形成了一种很特殊的局面。像射击一样，你瞄准的方向偏了，偏一点，最终，你射到的目的地就会偏很多。这种理论方向的偏差，造成了一种局面，所有中医都将经方理论奉为经典，但是几乎所有的中医在临床当中，真正使用经方者，少之又少，形成这么一种特殊的局面。原因是什么？你从这个条文里边就能看到，非常清楚。降一字格排版条文的作者还有点含蓄，后头加附注的人就给你写得很明白了。就这么一点一点的，把整个经方理论弄偏了。

“若小便自利者，不能发黄”，如果小便通畅，就形不成里湿热的这种环境，所以也就不会发生黄疸。这跟经方里边造成黄疸的病理是一个意思，绝无“太阴”之说，既无阴性证，也没有里虚寒证，它没有这些基本的特征，哪来太阴病呀？！所以说“系在太阴”，就不是指的太阴病，它就是指的脏腑经络。再接下来这有四个缺字符，我们现在就无从考证了。

“至七八日，虽暴烦，下利日十余行，必自止”。因为四个缺字符是不知道了，咱们就只能从仅仅能够看到的这些文字上面来进行解

读。虽然它论述的这种情况，咱们今天在实际临床当中，或者是在我们能够查阅到的临床医案当中，这一类的情況并不常见。好好的，下利一天拉十几次，自止了，病也好了，这类情况并不太多。

这应该是人体自我痊愈的一种过程，并且在这个过程当中，发生了一种自愈以前的瞑眩状态。“至七八日”实际上就是人体形成自愈机制的一个前驱期，它得有这么一个时期。人体不会说得了病以后，今天挺严重，第二天马上就好了，这种可能性不大。总是要人体的免疫力和疾病有一个相持阶段，到最后它如果占了上风的话，那有可能就会出现这一类的情况。

“暴烦”这就是一个瞑眩状态。

“下利日十余行”，这也应该是一个瞑眩状态。但是它跟“暴烦”不一样，“暴烦”是一个精神方面的状态啦，但是下利，是人体在机能恢复以后，里饮得以从这个消化道当中排出，里热也随之排出吧。所以这样的下利，虽然看似病势很严重，但是当人体的里饮和里热消除之后，就会“自止”了。

附注“以脾家实，腐秽当去故也”，“腐秽当去”指的就是这一类的意思。当然这个“脾家实”，也就说人体不是那么虚，有这方面的意思。仅就它对原文的注解而言，并不为错。但是我们从中能够看出，经方理论是怎么一点一点地被篡改为病位辨证的。如果原文的作者在“系在太阴，身当发黄”当中还没有直言脏腑的话，这个地方就将脏腑进一步地明确出来了。之所以我们在这儿要强调经方辨证体系既不是脏腑辨证、也不是经络辨证、也不是部位辨证，它辨析的不是疾病的事实，没有这个意思。而是它们与经方医学的辨证体系和经方的临床应用都不能接轨，真正的经方医学是不讲这个的。因为经方在临床应用当中没有这种规律存在。所以说那些东西跟这些东西是接不了轨的。

这些都是理论上的一种说辞，我们可以以一个具体的疾病来进一

步的剖析一下：

我常用一个肝炎做例子，因为肝炎这种病，目前传统中医和现代医学，疗效都不是说特别好，都有治好的，但是也有大量治不好的。它的发病机理，各有各的说辞，肝脏发生病变是一个不争的事实，你不能说不对，你说它是肝炎也好，或者说它是肝阳上亢也好，这种结论本身也没有错。但是与经方的这种理论来对照一下，你会发现，这些结论，这些对疾病的认识，看似百分之百的是一些实实在在的问题，但是它却只是研究了疾病的一个表象。是什么原因造成的这种疾病？因为技术手段还不足够先进，它还无法认识到这种疾病的原因是什么。所以用这一类的理论、方法来治疗疾病，常常是时效时不效。真正临床中中医有效，不是因为它的脏腑经络辨证而取得的效果，而是它在辨脏腑经络的同时它也辨寒热虚实，它是因为这个取效。现代医学它治疗虽然说是另一套体系，它把治疗的目的集中在控制致病因子上，但是实质上出不了这个规律。因为它对疾病的认识片面，它只能去看看到致病因子这一块。

这两天上海还有哪儿已经出现了（H7N9 禽流感），上海有两个病例已经死了，这是全球首次在人身上得病的这么一种病，而且非常重。一开始报道这个病的时候，所有对病者的报道都是说他有没有外出的经历，有没有接触禽兽这一类的条件，到最后发现，其中只有一个人真正的是在那种环境里边，而且他在那个市场离卖家禽的那一类的还比较远，但是他们就不去给你解释另一个问题，如果说他是从这个渠道传染得病的话，人家那个卖家禽的人为什么不得病呢？因为这个事儿太明确了。今天的报道开始触及到问题，就是说这几个病人，都有一个共同特点，他们都还伴有其他的疾病。换句话说就是，他们身体状态都很差，其实就是自身的免疫力很差，真正想解决问题还是要通过提高自身的抵抗力。如何来提高自身的抵抗力？抵抗力弱，弱在哪儿呀？怎么弱了的？现代医学有一套提高免疫力、提高抵抗力的

一套办法。大家去看看那些办法，有真正管用的吗？有人真正通过那种办法健康了吗？包括他们的医生。不是说他们有意的怎样，是受技术手段的限制，现在研究不到人体为什么会抵抗力降低，具体的原因是什么。其实避开这一类的，不要去钻死牛角尖，回到现实生活当中来，离开那个科学迷信的圈套，然后你再去重新审视一下。你会发现什么？把人和动物相比较一下，所有的动物要如果没有天敌的，几乎都能寿终正寝，它们得不得病啊？农村里边，家里边养狗，如果不是把它杀了，不是把它打了，或不是把它卖了，它都能寿终正寝。它得不得病啊？得呀。有时候也会趴在那儿好几天不吃东西或者拉稀的，但它都能自愈，可是人现在就没有这个能力了。你一旦站在这个角度去看，你就会发现人类好多所谓的健康措施，实际上不仅仅不能让你健康，而且还能损害你的健康状态。

现代医学去控制致病因子，其实它也脱不出这个规律来。因为它只知道致病因子这一个方面，人为什么没有能力限制致病因子的数量呢？关键的问题还是出现在人自身上。现代医学虽然掌握了最先进的技术，还不足以研究到这种程度，这些问题还没法清晰解答出来，它也不能有效地改善人体自身控制疾病的能力。

咱们扯那么多，说了一些其它医学当中片面的方面，经方医学是怎么回事？你就这么高级啊！咱们看一看：经方医学对于肝炎这种病的治疗，有临床统计资料明确地显示，就这一个肝炎病，有应用机会的经方就有六十个之多。这说明什么？说明了真正的经方医学治疗肝炎，认为肝炎的发生，在不同的患者身上，至少有六十种以上的不同的病理状态所造成的，换句话说，虽然都是在肝脏上出现炎症，但是它们却是六十种以上的疾病状态，或者说是六十多种疾病，在不同的个人身上，当然他就大概只表现一、两种。就因为这样，所以说治疗也自然不同了。

经方怎么治啊？你得了病以后，现什么症状就用什么方剂来治，

现什么方证就用什么方剂来治。我不管你是不是肝脏发炎，还是心肌发炎，还是肺发炎，不管这一套。当然在辨证当中，现在我们对它认识得很清楚，也可以把它当作和症状一样的一个参考因素来考虑。但是如果拿它（肝脏）当治病的依据是没法用经方的，这就是经方医学。

在经方医学当中，一种具体的疾病，一个或者多个器官和组织部位发生了具体的病变，与人体患病所表现出来的具体的症状一样，都是人体整体疾病的一种具体的表现形式，这就把它跟别的医学分开档了。在别的医学里边，这个具体部位发病，是疾病的核心，都围绕着它开始研究。但是经方医学不是，经方医学是真正地、整体地研究人类，通过人患病以后的各种症状表现形式。只有将这些症状反应，以经方医学的辨证方法进行综合地分析，这就是经方辨证过程。你才能得出人体整体处于一种什么样的病理状态，并且进一步确定在这种病理状态下，具体为何种方证。这不就是我们说的先辨病理，然后再辨方证吗。

这就是经方医学的病理辨证实质。你从这儿再反过头看一看，所有的以脏腑、经络、病位、组织、器官等等为核心的医学体系，所研究的只是疾病的一个侧面，而不是整体或全部，只有经方医学才真正找到一条以人体患病以后所表现出来的症状反应为依据，进而寻求对疾病进行整体治疗的有效的途径。关于这个问题，胡老做过专门的定义，很专业。

本太阳病、医反下之、因尔腹满时痛者、属大阴也·桂枝加芍药汤主之、大实痛者、桂枝加大黄汤主之、（279）

桂枝加芍药汤^①

注：《宋本》作“桂枝加芍药汤方”。

桂枝三两去皮 芍药六两 甘草二两炙 大枣十二枚擘 生姜三两切

右五味、以水七升、煮取三升、去滓、温分三服（注）本云桂枝汤·今加芍药·

桂枝加大黄汤^①

注：《宋本》作“桂枝加大黄汤方”。

桂枝三两^① 大黄二两 芍药六两 生姜三两切 甘草二两^② 大枣十二枚^③

注：

1. 《宋本》此处有“去皮”二字。
2. 《宋本》此处有“炙”字。
3. 《宋本》此处有“擘”字。

右六味、以水七升、煮取三升、去滓、温服一升、日三服、

胡希恕：“本太阳病，医反下之，因尔腹满时痛者，属太阴也，桂枝加芍药汤主之。大实痛者，桂枝加大黄汤主之。”这段是有语病的，啊。但是他那意思不是这个。他说“本太阳病”，太阳病依法当发汗呐，不可以吃泻药，啊。遇着这么一个糊涂大夫，啊，“而反下之”。一下虚其胃肠，引邪入内了，啊。所以“因而腹满时痛者”，这一个腹满时痛啊，怎么叫做“属太阴也”？他不是太阴病，要是太阴病还能用大黄吗？是不是啊？太阴病不可下，你看看头前儿，“若下之，必胸下结硬”。那么这一个他就证候他来让你鉴别呀。由于太阴病啊，他说，有自利益甚、时腹自痛，又有腹满，那么就证候上说属太阴，他是就这个片面证候上来说。这正是叫人鉴别这个，真正的太阴这种，啊，腹满时痛啊，与这一个本方证，就是桂枝加芍药，桂枝加芍药大黄，这一种鉴别法儿。所以，我们在临床上啊，不要以片

面证候就下结论的，非全面看问题不可。他这个本来是太阳病，误下引邪入里，这一个腹满是实满，不是虚满，这一个痛也是实痛，也不是虚痛。不像太阴病那一个，但是证候呢，属太阴，他这意思是主要在这一点。所以这一个方子呀，不是治太阴的哟！他由于表没解呀，他下之后他没发汗，表未解。所以仍然以桂枝汤为主的，用桂枝汤原方。由于腹满时痛，这个芍药治腹满，同时治挛痛，这个芍药是个“苦而微寒”的药啊，它治热不治寒，治实不治虚，所以这一个“腹满时痛”不是我们讲那个太阴病的他那个“腹满时痛”。那么如果大实痛者，啊，拒摠，啊，而且这个满的也厉害了叫做“大实痛”了。可见这个大实痛，与上面那个是什么呢？那一个也是个实痛，不过不大而已呀。真正大实痛，要大便也不见，不但加芍药还得加大黄。所以这个怎么是太阴病啊？这个著书的呀，他就是误于这一个…一看有个太阴病，这也算个太阴病。它不是太阴病。可张仲景作这个书啊，它是有语病的，啊。它这个也不应该列到太阴篇里头。不是你往这列干什么呢？啊。所以，这个，啊，所以我们读他这个书啊，不能因词害意呀。一个“属太阴”，啊，就认为这是个太阴病。真遇着太阴病，你搁芍药大黄，那一治一个死，啊，它不是。它是属于实满、实痛，啊，如果实满、实痛轻微者，用芍药就行，他表不解你得配合桂枝汤啊，所以桂枝汤加重芍药就可以了。要是大实、大满，那你非通大便不可，还得加大黄嘛。那么太阴病不渴，不可下，这怎么下呢？它不矛盾吗？与这个提纲就矛盾了。你怎么统一起来呢？就这一个不是太阴病。要真是太阴病，那…那张…那仲景那太糊涂了，啊，那一个说不可下，这又可下，哪有这个事儿啊！这不对，是吧？但是搁到这一块儿啊，给这个注家，就是迷…容易迷惑读者，是吧？所以读他这个书啊，非要根据他这个全面，把这个规律呀，好好掌握，才能够用这个书，要不然的话，不能用啊，啊。这也很…挺要紧，啊。所以桂枝加芍药汤啊，不应该列在太阴篇里头啊；桂枝加大黄汤更不能列到太

阴篇里头。那么他这个方剂呢，他是表还没解，所以搁桂枝汤。这个芍药这个药，咱们头前儿讲过那个芍药甘草汤治拘挛呐，啊，四肢急，拘急，脚挛急嘛，它也能够治拘挛，这个都…啊，同时也能够缓急痛，啊。所以咱们这一个，啊，是这个腹急痛大概都加芍药。那么加大黄汤呢？就跟上面加芍药汤再加上大黄一味，啊，不但缓其痛而且去其…攻其实。你看看后头就有了，他当时就怕你误会

李冠杰：下边我们解读一下：

“本太阳病，医反下之”，是指对于太阳表证误用下法。对于这类情况，在太阳篇里面，早就有详细地论述。凡是太阳病如果误下以后，仍然处于表证的病理阶段，而且没有发生其他类型疾病的这种情况，都要用桂枝汤来治疗。那么，这个条文论述的，就是在这种基础之上，出现了其他的变证。他论述的就是这么一种比较特殊的情况。

出现了什么变证呢？因为对于表证误下，造成了“腹满时痛”的这种症状。这个“腹满时痛”，跟太阴病的提纲里面症状反应，就比较近似了。

那么这儿的“腹满时痛”，从治疗方剂上来看，这是表证误下以后造成血虚，而出现的“腹满痛”的症状。在临床当中，这种腹痛常常表现为：绵绵的疼痛，连绵不断的疼痛或者隐痛，或者阵发性的疼痛。这种腹痛跟芍药甘草汤证的腹痛，无论从病理上，还是从患者的主观感觉上，都有相似之处。

临床统计资料显示，桂枝加芍药汤证当中，下利出现的几率也挺高。这个也很可能是这个条文出现在太阴篇的一个原因。桂枝加芍药汤，治疗的是在表虚证的病理状态下，同时人体腹部的组织发生血虚证，而造成拘挛痛的这种情况。它的药物非常明显，总不能桂枝汤证，因为加了三两芍药，就变成了阴证。因为本身就有芍药，芍药再增加三两的量，就变成了太阴病了？这不可能的事。那么从方剂来看，治疗的就是这类的情况。而且从临床资料看，它也是治疗这类的情况。

但是这一条论述的这种情况，是由于表证误下所造成的，其实没有表证误下的这种病因，只要是表现为这种病理机制，就属于这个方剂的治疗范畴。

那么“大实痛者，桂枝加大黄汤主之”。这儿的“大实痛”，指的就不仅仅是腹满痛，而且还会有腹痛拒按的，大便不通，有里实证的症状反应。而桂枝加大黄汤，治疗的就是在表虚证的基础上，既有血虚所致的拘挛痛，同时又出现了里实证的这么一种情况。

这个旁注：“属太阴”，这是一个很明显错误的解释。这是涉及到对这种疾病定性的问题。究其原因，实际就是注解的作者，在对经方理论还没有真正看懂的情况下，机械地解读条文的产物。他机械在哪儿呢？就看这个症状跟那个太阴病条文里面的症状反应比较接近。

这个条文所论述的两个方证，实际都不是太阴病。从方剂的药物组成就能明显地看出来。

那下边我们再来看看方剂，桂枝加芍药汤证的病理，是表虚证又合并血虚证；那么，桂枝加大黄汤证的病理，是表虚证合并血虚证又合并里实证。

做个小结：本来患者得的是太阳表证，但是医者却误以泻下的方法治疗，因此而造成患者不单表证未除反而出现了腹满时痛的症状，这不属于太阴病，为桂枝加芍药汤主治之证。如在上述情况的同时，又出现大实痛的，则为桂枝加大黄汤主治之证。这样呢，这个条文就理顺了，就不容易理解错了。

桂枝加芍药汤是由五味中药组成，跟桂枝汤实际上药味是一样的，只是芍药由以前的三两改成了六两。所以，这个方剂的适应证，实际上就是桂枝汤证伴有芍药甘草汤证，而且，主要表现为血虚而致的腹部挛痛。我们可以简单地这么理解。实际在临床当中，这个方证还会伴有腹泻这一类的症状。太阳病用了下法，所以他会有腹泻。但是，没有误下误治这个过程的，这一类的情況出现腹泻的频率也比较

高。还不仅仅如此，这个方证，有时候还会出现便秘的机会。从方药组成来看，就是桂枝汤证也有下利。但是桂枝汤证出现下利的几率，远没有桂枝加芍药汤出现的几率高。这儿的下利，在病理上就跟血虚所造成的胃肠痉挛有关。

桂枝加芍药汤的方证：

症状：腹痛、腹胀满、下利、消瘦、神疲、发热、恶寒、头身痛、便秘。需要跟大家说明的，在临床医案当中，腹痛、腹胀满，下利、消瘦和神疲，这几个症状出现的几率很高；后边的发热、恶寒、身疼痛、便秘出现的几率相对就低。但是，这实际上有一个什么样的倾向呢？这个医者就是因为原文当中有后世所加的误导，有这种因素存在。所以都偏向于，像神疲、消瘦，想说明有阴性证。

舌象：淡舌。

舌苔：白滑苔、薄白苔、白腻苔。

脉象：沉脉、缓脉、浮脉、弱脉、滑脉、弦脉、涩脉、细脉。

现代疾病：慢性肠炎、慢性胃炎、手术后肠粘连、肠狭窄、腹膜炎、胃炎、胃溃疡、胃术后疼痛不休、慢性肝炎、慢性胰腺炎、胃癌疼痛、细菌性痢疾、痢疾、胃下垂、腹部手术后腹膜粘连疼痛、肠管狭窄、食物中毒、便秘。

下边，再来看看桂枝加大黄汤。桂枝加大黄汤有六味药组成，就是在桂枝加芍药汤的基础上，加了二两的大黄。它的适应症，就是在桂枝加芍药汤的基础上伴有里实证。那么，这个方证也可以视为是桂枝加芍药汤证中，那种便秘倾向更加的严重化，不仅仅是便秘的问题，再严重就发展为里实了。所以，它的病理基础跟桂枝加芍药汤是一致的。这种里实，究其原因也是因为血虚，影响了胃肠的正常功能，造成了肠道内的内容物积滞，而形成了里实。

桂枝加大黄汤证：

症状：腹痛、腹胀满、大便秘结、恶寒、发热。这个地方明确恶

寒、发热。

舌质：舌体肿、淡舌。

舌苔：白苔、腻苔、黄苔、燥苔、薄苔。

脉象：沉脉、缓脉。

现代疾病：感冒腹痛、慢性肠炎、疹出不顺腹痛、顽固性荨麻疹、慢性阑尾炎、慢性肠炎、机械性肠梗阻、痢疾、肠炎伴有里急后重者、便秘、肠痉挛性便秘、肠麻痹性便秘、肺炎。

学了这两个方证以后，有些问题值得我们做进一步地探究。

值得我们注意的是：在桂枝加芍药汤和桂枝加大黄汤证这个临床统计资料当中，都有下利和便秘的症状出现。包括桂枝加大黄汤，也有那个痢疾。以至于有的注家这样解释：桂枝加芍药汤既能治下利又能治便秘，有双向的调节作用。实际上这没说到点子上。要真正理解这两个方证当中的下利和便秘，必须要知道，到底是什么性质的便秘和下利。

那么问题到这儿呢，我们就有必要参照一下芍药甘草汤证。芍药甘草汤证的里虚、水虚这是甘草对应的，也就是津液虚；血虚这是芍药对应的。如果，我们把病理因素当中跟甘草相关的里虚和津液虚剔除出去，剩下的就是以拘挛痛为主要症状反应的血虚证。而芍药，恰恰有改善这一类病理的作用。

临床实践证明：芍药甘草汤也有治疗便秘的功能。好多人拿它来治疗便秘，也不是见到便秘就能用它治好，没有这个病理是治不好的。那么，这种便秘是怎么造成的呢？实际上，就是因为血虚破坏了胃肠正常的功能。因为不同的人，他的内环境是不一样的，有的人同样是这个病理，他会出现下利；有的人就会出现便秘。实际上是这么来的。

在这个基础上，再来看看桂枝加芍药汤证中的下利和便秘，就变得非常清晰了。就是因为一方面有表虚证的因素存在，另一方面又有血虚影响到了胃肠功能这种情况。只要有这两种因素存在，不管是出

现便秘也好，还是下利也好，都能用这个方子来治疗。必须是以桂枝汤证为基础，再加上血虚的因素，必须得具备这样的条件。没有这个病理特征，这个方剂，既不能治下利，也不能治便秘。这正是临床当中应用经方的一个关键所在。

至于桂枝加大黄汤，就是便秘的倾向更严重，形成了里实，那就需要加大黄来治疗。

我们在这儿需要再强调的是什么呢？需要再强调的是病理辨证的范畴。在实际临床当中都是以症状的形式表现出来的。如果明白这个病理的道理，再来鉴别症状，就很容易把这个方证，辨得比较清楚。比如：“腹满时痛”这个症状，因为没有严重的里虚寒证，所以不会有那种明显的喜温怕冷，下利清谷，脉沉迟这一类的症状。而这一类的拘挛痛，跟里寒证的那个腹痛，疼痛的方式也不同，病人的感觉也是不同的。区别都是比较明显的。

实际临床当中患者的情况，是复杂一些，但是，这一关必须得过。你过不了这一关，很难提高实际临床疗效。

大阴为病、脉弱、其人续自便利、设当行大黄芍药者、宜减之、以其人胃气弱、易动故也、①（280）

注：《宋本》此处有“下利者，先煎芍药三沸”九字。

胡希恕：他说，太阴为病，脉弱呀，其人续自便利，设当行大黄芍药者，宜减之，以其人胃气弱，易动故也。他就怕你拿这一个，啊，见着“腹满时痛”你就是用这个东西也不行的。他说，真正太阴病啊，脉一定是弱的。这个弱也挺概括呀，啊，就是虚弱之脉了，脉沉微呀，啊，沉弱呀，都属于脉弱之类的了。“其人续自便利”，头前儿说这个“自利益甚”这一类的太阴病了。继续…啊，他自下利，你也看着这个“腹满时痛”了，啊。这假设，这个腹满时痛像头前儿这个样子，

而可以用芍药大黄，这你可不要用。“宜减之”，不是减量，不要用，（减去、去掉的意思）。什么道理呢？真正里头要是寒到那个分气上，这个也一定虚，胃气弱。你…这个苦寒药啊，搁上就是下利不止，“易动故也”。所以他这一段正是给上一段，啊，让你对着，对照着看。所以上边那一段呐，并不是属于太阴。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降两字格排版的条文。

《宋本》里还有“下利者先煮芍药三分”九个字，《康平本》没有。

咱们解读一下：

这条条文的本意，就是太阴病属于虚寒性的疾病，常表现为脉弱，并且“其人续自便利”。如果需要使用芍药或者大黄的话，要减之。

“宜减之”，可以作两种理解：一是减量，二是去掉不用。这个条文的意思，就是因为太阴病本来就是胃功能比较虚弱，用这一类的药物容易发生变证，就是这么一个意思。

但是在经方理论当中，用药遣方的原则非常得清楚——有是证用是方。这儿的证都是经过经方辨证体系分析辨证之后，得出的符合用药遣方病理的证据，不是一个孤立的症状，绝对没有某类疾病当用某药而不用的这种道理。从经方的用药里边，绝对读不出这种道理来。这儿的的关键是什么？关键是有没有应用芍药和大黄的证候。这条条文就分析到这儿，大家可以仁者见仁，智者见智。

太阴病小结

胡希恕：那么这个太阴病到这就完了，是吗？其实他…他…他，不是的。头前儿咱们讲了那么很多，啊。你像这个“下利清谷”啊，啊，啊…咱们用那一个，啊，头前儿讲四逆汤 啊，啊，那呀，全属于太阴。这太阴的这个死亡啊，就在这个阶段。这个太阴病要是不治，这个胃气衰败到极，就不可复还了，就非死不可。那么这些病他都没搁到太阴篇里头，为什么呢？他有他用意的。这个太阴病啊，跟阳明病一样，全是从表，或半表半里转属而来的。他把太阴病的死证啊，都搁到我们下一篇了，搁到少阴篇少阴病里头。他这个也有大道理的，这一个少阴病啊，跟太阳病全在表啊。他这一个是人素虚，或者是老年人，这个气血虚衰的人，得了外感，一发作就是少阴病，“脉微细”……（音频缺如）……讲了，这个表证就是邪气交争于骨肉啊，在体表作战。体力虚衰现这个少阴病，支持在表的时间最短，他支持不了。所以我们讲了少阴病就好了。他说，少阴病，二三日无里证，可发汗，啊，可与麻黄附子甘草汤微发汗。二三日，他就是两三天，无里证，那都是在表了，无里证什么，就在表嘛，现在一般人不认为少阴病在表，不在表这一段怎么讲啊。他就在表，可在表的时间最短。你像我们讲那个太阳病七八天，啊，嗯…才传里，六七天，甚至于十余天还…还有时候在表呢。这个少阴病不行，他几天就是并发里证。一并发里证就是太阴病，呕吐下利，四肢厥冷都来了，这一个马上就有死亡可能啊。所以他把太阴病的死亡病啊…死亡证啊，他全摆

到少阴篇里头了。干什么？那就是警告医家呀。说我们在临床上遇到这个表证，啊，真正是脉微细，人但欲寐这一种情况，不可轻视啊，转瞬就可死亡，他一病里就危险。所以得抓紧时间，就是两三天的时间，他是这个表证，那你用这个麻黄附子细辛呐，或者…啊，麻黄附子桂枝证…啊…麻黄甘草附子啊，这…这就是还可以望其生，能够救。你们看这个报上有的是啊，这个老人得感冒死亡最…最多。他为什么？他就是这个关系，几天他就是转变到这个，啊，太阴病。转到太阴病，这个死亡的机会是最多啊，他本来就虚，又转为少阴病…哦，这个转为太阴病，那一个胃气败那是最快了。所以他这个…他这个书啊，是得好好读，是吧？他太阴病呢，他不讲这个，这个东西都来后头呢。头前他也讲一讲，讲这个，这个里虚的这个重要性。所以在太阳篇也讲了，啊。他说“下利清谷”，虽然有表证，当救其里，啊，不要管表。因为这个…这个胃气一败人就有死亡的可能啊！他虽然这么讲了他不详细。那么在太阴病呢，他把太阴病正面的证候指出来了，啊，“腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛”，那么这个病是不能下，啊，“若下之必胸胁结硬”。这是正面的证候。那么也有些似是而非的。你像我们方才讲这一个，啊，桂枝加芍药，桂枝加芍药大黄，这一个都不是真正的太阴病。但是这一个临床上要辨，你必须分别，啊。那么如果真是太阴病的那一个“腹满时痛”，啊，那你不能够用这个芍药大黄，这是很清楚，啊。那么可是这个…太阴病的这个一切危险证候和治法，他一句话，在这儿就说明白了，什么？“宜服四逆辈”。所以这一章啊，你别看它短，它都全了。少阴病下利，只是用四逆辈，旁的那是不对的。旁的他都是略略的给你说，你像那个，啊，“太阴病脉浮者可发汗”，他冲着下利一…一证而说的。这就是照应头前儿那一个葛根汤，你们好好看自然就明白了，啊。而且少阴病还有一个白通汤。那么主要的这个证候在这儿呢！所以这个下面，凡是四逆辈都是太阴病，那还有说的吗？不能说是这个，啊，在

这儿，啊，是太阴病的治法，后头遇着用它了就不是太阴病了，哪有那个事儿呀！那个书那是…还怎么…它不是一个普遍的事情了，那个东西都没有法可寻了。那你学什么辨证啊？所以他这个书是一贯的。既提出一个四逆辈，你们后头看吧，凡是用四逆辈者，都是太阴病之里虚寒。他精神在这儿，啊。所以看着少，这几节，但是它是无一不备。所以会读这个书的，你就能够读出这些问题来，不的话不行，啊。那么尤其这一个，他这个书啊…所以我上次也说，这古人呐，他是通过实践，啊。通过实践，他是发现上疾病的规律和治疗的一种方法。这个都通过实践来的。这一个东西永远存在的，它客观存在嘛，啊。可是古人对这个认识啊，有些是不足的。你像咱们这个六经，这个六经它是一个自然而然的，它是六个疾病的类型。怎么来认识它？讲其我们再讲一讲，我给…咱们再，啊，讲一讲这个六经啊，和八纲等等这一种情况。那么现在我们就可以知道，它就这么几个类型，就这么来…来认识它就对了。古人呢，也是这么认识的，他就要…要发明这个……发挥里头这个理了。为什么就这么六个类型呀？所以他就想到这一个，啊，针灸这个经络之说了。他…他给起一个，啊，用六经来名之，这东西害人，害不轻。所以历来这个注家呀，就是在六经上啃。这个六经，这个名字又来之于《内经》，就拿《内经》来附会，来解释伤寒。这是坏透了，啊。这个王叔和是首…首先，你们这个…咱们这个《伤寒论》没有啊，你你看那个成无己本就有了，他头前儿有个伤寒例，这是王叔和作的。王叔和采集仲景遗论，这是功垂千古啊，啊。要没有王叔和恐怕这个书传不下来。但是他就是没认识这个书，他也没法认识，他也是古人嘛。他就认为这个书，这个伤寒呐，就是说的这一个《内经》上这个伤寒。所以他在头前儿写一个伤寒例。这伤寒例头一句话就是“阴阳大论曰”，啊，他就是整个用，把这个《内经》上论伤寒这些他都抄来了。那么后世这个注家，受王叔和的影响很大，也认为他这个书啊，来自于《内经》。咱们现在还说嘛，说这

个《伤寒论》呐，就是从《内经》又发展起来的。你们想想可能不可能？《内经》可以说不是个方…方书，它里头没多少方子。一个人就通过《内经》，就能作出这么缜密，啊，这么样子肯定，我们通过临床实验这么样子正确，不会有的。谁有那么大的聪明啊？那除非圣人。又是现在咱们又不信这一招…圣…圣人，没有嘛，那他怎么可能。那《内经》还有呢，你根据《内经》你搞一搞，他不可能的事。可是大家现在都这么说。所以，啊，这个一提起这个经，就是经病，又是腑病，脏病就扯起来了。所以这一个书啊，这个真正的辨证的这个体系、经义，反而是晦而不彰啊。那么到现在，你问一个人，说是《伤寒论》这个辨证，啊，怎么一个方法体系呀？说不上来。他这个注家都没在这个地方下手，啊。所以这一个，古人这个认识有时候是错的。他对于这个经络的认识啊，就张仲景也不例外，他也没改嘛。他也就是个…啊，太阳病、太阴病嘛。所以这一个，与这个后世影响很大。咱们今天就讲到这儿了，啊。这个……我想咱们听…啊，听完的同志们呀，大家也发挥发挥，啊，自己好好琢磨琢磨，我说的不一定都是对的，是吧？这个人都是，啊，没有说是整个把它说对的，啊。大家有什么问题呀，提出来咱们讨论讨论更好。哪一个地方啊，说是，啊，还是要好好…把这个讲过的东西呀，要好好看一看。咱们今天就…就…就…就讲到这儿了。

李冠杰：太阴篇总共有八条条文，从 273 条到 280 条，在《康平本》里一共有七段，其中顶格条文只有两段，降一字格排版的条文有三条两段，降两字格排版的条文有三条，另外方剂有两首。

从论述的内容上看，这些条文只有顶格条文中的第 273 条是对太阴病的概括性论述。虽然文字不多，但是包括了太阴病的主要病理和治疗原则，以及治疗禁忌，并且还指出了太阴病误治以后的不良后果。虽然这篇里就这么一条，但是将在其它篇中论述的一些阴性里寒证相关的条文结合解读，整个太阴病的方方面面基本上也就都包括了。

顶格的第二个条文就是第 279 条，应该理解为：将在症状反应上，与太阴病较为接近的两个互相联系的非太阴病方证放在这一篇中，目的是要读者注意与太阴病之间的鉴别，并且以此角度可以帮助读者进一步地理解太阴病的病理。虽然症状反应相似，但是在病理上有本质的区别，可以进一步地去体悟太阴病的病理是什么。

篇中顶格条文之外的条文，能明显看出来是由于作者对太阴病病理的理解存在不同程度的偏差，所以论述的内容或者是非太阴病，或者是与经方理论相左，学术价值都不是特别高。其中只有第 276 条，明确地提出了桂枝汤证中可能出现与太阴病近似的“下利”症状反应。这应该是对经方理论的补充，大家可以查一查条文，在顶格条文里都没有明确论述桂枝汤可以治疗下利的。

我们稍微再做一下延伸。太阴病如果用病理辨证划分，它是阴性的里虚寒证；也有阴性的寒实证。从表面上看，跟三阴三阳的划分章法之间没有质的区别，但是，如果把经方中所有的方证都在辨证纲要中归纳进去，就会发现病理辨证方法比仅分六大类的划分方法更恰当一些。比如在太阴病中，我们刚才提到了一个比较特殊的方证——大黄附子汤，它就是一个阴性的里寒实证，要归到别的类型疾病里是归不进去的。要是用病理辨证来划分，我们可以非常准确无误的将这个方证的病理全都很恰当地概括进去，它就是一个阴性的里寒证、里实证。如果再拓宽一点，许多其它的方证都能概括进来，而且还能把人体患病以后复杂的、各式各样的以方证为表现形式的病理状态，几乎都能很吻合的纳入进来。比如像水证、血证，这六大类是无论如何概括不了的，还要另外以条文的形式再说明。但是在病理辨证上，就很恰当地纳入进来了。

但是，如果用三阴三阳的方法再划分，大黄附子汤证中寒实的属性，在六类疾病中就没法明确地与其它方证区别开来。而且还有一个更为严重的问题：它属于太阴病，太阴病有一个治疗原则是不可下，

可是大黄附子汤就是一个泻下的方剂。我用它治疗尿毒症，那个人就是脉迟，一片寒像，但是大便不通，用这个方剂就好使，疗效非常好！而且他各项西医的指标都有改善。但是要把它放到太阴病里，与太阴病的治疗原则就不太合适，尽管就这一个方证，也必须作特殊的说明。因为经方里不能把哪一个方证孤立起来，这些方证都是一个典型的病理状态，围绕它还会延伸出其它的方证来。从这个角度，就会发现三阴三阳的划分方法，在经方理论体系里作为辨证体系的一个主要纲要，实际上是在当时的历史条件下不得已而为之。因为这样能够用最少的文字说明最复杂的问题。

其实，这种病理辨证并没有加入新的东西，都是经方里明确论述到的，只是那个时候没有用这种方法来进行分类而已。所以在这儿再强调一下，希望大家对经方的辨证体系能有一个深入的认识。这是我们临床提高疗效的一个基础。

辨少阴病^①

注：《宋本》作“辨少阴病脉证并治第十一”。

少阴之为病、脉微细、但欲寐也、（281）

胡希恕：这个少阴病啊，根据八纲来看它就是表阴证，啊。嗯…也不是什么一个特别的病。古人的看法呢，他说是这个…那么古人给起一个经络名称，啊，所把大家把这个少阴病啊，就弄…弄糊了。那么古人对这个规律的认识啊，这是他通过实践，那肯定那是没问题的，啊。他是客观存在嘛。那么，对于这个认识是有问题的，他古人那个时候，他限于科学，所以这个说是经络受邪发病，这一个与后世这个辨证很有影响。我们先…啊，根据书讲一讲，完了咱们再…啊，再讨论，这一个值得讨论的。那么他开首啊，他说了一个少阴…少阴病的题纲。那么这个题纲的意思，这是后世注家的说法。所谓题纲者，就是概括这一个病的一个概括说法，啊。题纲者，就提挈纲领嘛。那么以…以下也都包括这个概要，这个纲领，那才对呢。那么我向来都认为这是一个特征，那么少阴病的特征，太阳病的特征。那么也就是，见着这一种证候就属于某一种的病，所以叫特征也可以的，啊。那么，他这个头一节儿是这么说的，“少阴之为病，脉微细，但欲寐也”这个少阴病它也是表证，他就没详细谈了。这就冲着太阳病来说的。那么一般的这个表证，啊，它也类似太阳病啊。但是脉虽然浮，比较微细。这个微细呀，见着于浮啊，啊。同时由于这个少阴病，是虚。所

以这个人呐，“但欲寐也”，啊，喜欢躺着。卧，喜卧，啊，他困倦。就是我们平时遇着这个感冒，这一种病啊，不过少，啊，还是这个太阳病多。那么身体特别虚的人，或者老年呢，这个气血俱衰，那么得着外感呐，常常发生少阴病这一种证形，啊。就是脉，啊，不那么浮，而偏于微细。那么其人呢，虽然也有身疼体痛啊，啊，头痛项强这都有，但是，但欲寐，啊。我们应该这么理解这一段。

李冠杰：少阴篇的题目就是“辨少阴病”，在《宋本》里被改做了“辨少阴病脉证并治第十一”。

少阴病在三阴病中属于表证，在经方辨证理论中是一种阴性的表证。但因为受《内经》用经络定义“三阴三阳”的影响，历代注家很少将少阴病理解为阴性表证的，大部分人都把它理解成心肾两个系统出现的病变，直到胡希恕先生经过了一生地研究，明确地提出了少阴病是阴性表证的论断，还原了经方理论的本来面目。

经方理论应该是两千多年了，就是从张仲景到现在也一千八百多年，实际上在张仲景之前这套理论已经比较完备了。两千多年后，这个带有方向性的问题才被拨乱反正、正本清源，还原了本来面目。这本身就是非常不可思议的事。

如果对这个问题再做更深地分析，实际就涉及到了整个中医理论的传承问题。自古以来，学习中医必须从基础理论学起，几乎所有的学者都将《黄帝内经》奉为中医的理论经典和基础，将《黄帝内经》作为学习中医理论的必修课。但是，随着对中医理论研究的不断深入，越来越多的有识之士对这个模式提出了一些质疑。直到近代胡希恕先生的学术思想的形成，终于明确地提出了“经方理论与内经理论无关”的论断。这应该是一个非常了不起的论断，尽管这也是还事物本来面目的一个行为，但是比“少阴病是三阴病里的表证”这个论断的层面要高很多，更带有方向性。

《内经》和经方理论中的“三阴三阳”，学习过程中不止一次地

说过了，实际上用的是一种相同的分类方法，但是分类的对象不同。尽管说分类的对象不同呢，但毕竟都是发生在人体上的相关事物，一个是对人体体表部位的经络进行分类，一个是对人体患病以后表现出来的症状进行分类。正因为方法一样，所以分类的结果会有一些联系性。比如太阳病中的典型症状反应：“脉浮，头项强痛而恶寒”，特别是“头项强痛”这个部位与足太阳膀胱经的经络循行部位恰恰是一致的，就好像为以内经理论解释经方的提供了理论依据。在人体的经络里，太阳经络在人体上循行的部位最长，而且是最具浅表性的，有些解释是因为人体仰脸的机会特别少，弯腰的机会非常多。阳明经是因为人弯腰的机会多，所以阳明经相对太阳经就偏里。经方里的太阳病，实际上也是用了这样的分类方法，但分的不是人体的部位，分的是一些症状反应。在繁杂的症状里，从方证里把它们慢慢地分开类，把带有相同性质的方证分成一类，然后再给它起个名字，这也是很不容易的。

就因为分类方法一样，好像有一些地方出现了重合点，有点相似，但实际上并不是问题的本质。比如桂枝汤证和葛根汤证都有可能出现下利，这就跟太阳经络无关了，无论如何下利的病变部位跟膀胱经、心经都没有关系。中医里还有以五行来解释的一套理论，用五行生克来解释肯定能联系起来的。但是不出现下利的呢？大部分桂枝汤证和葛根汤证都没有下利，那五行理论又套不上了。所以这些东西很难去自圆其说了。

为什么我们分析这些东西？实际上，整体地看看中医理论和现状，中医整体疗效之所以很低就是理论上的偏差。但经方治病简直就是效如桴鼓、药到病除，但很多人用不了这样的技术，问题就出在理论上的偏差。只有弄清了上边这些问题，再学习少阴篇才会更容易把握它的精神实质。

实际上，三阴三阳这个分类方法中，少阴本身就是阴性类别里边

最接近于阳性的一种类型。它是阴性的表证，这是还原了经方理论的本来面目，经方辨证体系用它来定义阴性疾病中最具浅表性的表证，就是阴性的表证。它的典型方证就是麻黄附子甘草汤证和桂枝加附子汤证，其中一虚一实。把这个问题弄清楚了，再学习少阴篇里诸多的条文，包括一些非顶格条文，都比较容易理解了。

281 条，这个条文在《康平本》是顶格排版的条文。

我们今天学习的这些条文，只有这一条是顶格排版的条文。这条常被称作是少阴病的提纲。

解读一下：

“少阴病”是一种人体机能偏于沉衰的阴性表证，其主要的症状反应也会表现出这一病理的基本特征。

“脉微细”，就是指的微弱而细弱的脉象。这应该是少阴病中一种常见的脉象，但不是唯一的脉象。从临床统计资料说，没有哪一个方证单纯的表现作为一种脉象，这种方证基本上没有。少阴病是在人体机能偏于沉衰的情况下发生的表证。所谓机能偏于沉衰，首先就包括循环系统功能下降，所以常常应之于脉，就会表现为不及的脉，像又细又弱的脉，有时还表现为沉脉，有时也表现为偏于浮脉，但是细弱脉出现的频率是非常高的。

“但欲寐”，就是指患者呈现朦胧欲睡的样子，这是阴性证中一个典型的症状反应。实际临床中，这类的患者常常表现为喜卧，严重的甚至就是昏昏欲睡，同时还会伴有一些精神不振、少气懒言、喜静懒动、神疲乏力诸如此类的症状。用一句笼统的话说，总是有一种体力不支的感觉。但应该清楚另一个问题，这个症状并不是少阴病特有的症状，在太阴病和厥阴病里都可见到这样的症状，甚至有的阳性疾病里也会出现类似的症状。只有在人体机能偏于沉衰的情况下发生的表证，才属于少阴病的范畴。还有一个问题，少阴病一般会呈现出阴性证，这本身就是一个方向性的问题。

还有一个关于寒热的问题。刚才说的方证都是偏于里虚寒的，但也有偏于里虚热的，《金匱要略》里的竹叶汤证就是，虽然在临床中出现的频率比较低，但是我们应该知道有这类的情况，不是所有的阴性证都是偏于里虚寒的，不一定。

这条作为少阴病的提纲，虽然述证非常简略，但是如果把“少阴之为病”中的“少阴”理解为阴性表证（它本身就是这个意思），这个条文论述少阴病的基本特征就非常清晰了。所谓阴性病，实际上就是指在“脉微细，但欲寐”这种典型的症状反应的情况下，而出现的表证，那就是少阴病。因为少阴篇里有两个少阴病的基础方，一个是麻黄附子甘草汤，另一个是麻黄细辛附子汤。这两个方剂用药都非常得简，都只有三味药，治疗的目的也非常明确。所以说，这个条文对它的适应症论述得非常得简略，几乎都没有论述它的证，实际上在别的地方论述了。不仅仅是这样，包括少阴篇里没有的，像桂枝加附子汤证是少阴病里典型的表虚证，它的条文论述里也几乎没有论述典型表证的反应，在太阳篇里第 20 条论述桂枝加附子汤：“太阳病发汗，遂汗漏不止，其人恶风、小便难，四肢微急、难以屈伸者，桂枝加附子汤主之”。仔细看看，这个条文里几乎也没有表证的症状反应。它论述的症状里有一个“其人恶风”，这个是另有意思的，“恶风”本身是一个表证的症状，但是这里强调的是“恶风”比阳性表证要厉害，实际上论述的这些症状都是阳性表证里没有的，或者是不常见的。比如桂枝汤证是有汗出的，但它这里是“遂汗漏不止”，汗出比桂枝汤严重得多，其他的几乎跟表证没有太大关系了。这正是经方论述的一个特点。

麻黄附子甘草汤证也好，麻黄细辛附子汤证也好，桂枝加附子汤证也好，它们论述的在少阴篇提纲里，两个麻黄剂得必须是在麻黄剂的基础上又现“脉微细、但欲寐”。提纲里的这两个症好像数学里的常数一样，用的时候把它代进去就行了。表证在哪儿论述的呢？表证

在阳性病的论述里：“脉浮，头项强痛而恶寒”。把“脉浮”去掉，就是“头项强痛而恶寒”。现在学习的这条，其实我们也能清楚这也不是表证的全部，但是要点都有了。那么，也就是说在阴性证的基础上，它应该还有这些反应，在“脉微细，但欲寐”的基础上，还有这类的反应，这才是阴性表证。

那么，刚才说的三个方剂都有这个特征。它们必见表证，如果没有表证那就奇怪了，因为整个方剂都是解表的嘛。像麻黄甘草不就是麻黄汤的一个简方嘛！所以，这样再回头来看看，少阴篇提纲里论的实际上非常得精辟，只要把条文里“少阴之为病”的“少阴”理解为“少阴表证”，这个“脉微细、但欲寐”简直就太精道了。这是跟阳性证最明显的区别，在阳性证的基础上见着这个就是阴性表证了。如果理解到这儿，再回过头来看看这两个麻黄剂的方证条文虽然论述得很简，但实际上内容都有了。

少阴病、欲吐不吐、心烦但欲寐、五六日、自利而渴者、
属少阴也。虚故引水自救、若小便色白者、少阴病形悉具、（注）
小便白者、以下焦虚、有寒、不能制水、故令色白也、（282）

胡希恕：这一段呐，是有…啊，关照很多方面。第一个他说，少阴病，里头要停水的话，太阳病也是，也要有这种情形嘛。那么他就要吐，而又不得吐出，所以心烦。这个“心烦”呐，应该有个逗点，不应该再接着底下。他这个欲吐不吐心烦，啊，欲吐而不得吐，他心烦。“但欲寐”这是少阴病的本证。“少阴之为病，脉微细，但欲寐嘛”。他提出它一个特征。就是说在少阴病存在的时候，啊，已经得了少阴病了。有这一个“但欲寐”的证候的反应，同时他欲吐而不吐，而心烦。那么，他就是外边表现着太阴病…哦，少阴病，同时内里头有停饮，所以他要吐不吐而心烦，啊。应该作这么一种的体会。那么

这个少阴病本虚，它要传里呀，不等到这个八九日啊。咱们头前儿讲太阳病，五六天这传少阳的时间，那么六七日、七八日，啊。五六、六七日常传少阳，啊；七八、八九常传阳明。唯有少阴病他是虚，尤其里头再有停饮，有寒饮，啊，那传里非常快。一传里头这个少阴病传里呀，不像太阳，多传太阴而发生，啊，呕吐下利这一类的病。太阳病传里呢，一般常传阳明，发为胃家实那一类的病，啊。可也有，太阳病有的时候也传太阴；那么少阴病呢？也有时候传里，传阳明。后头也有，啊。但是这一个都是一个特殊…比较少。一般少阴病这一种表证，传里常传太阴，尤其胃有停水，他开始得病就是欲吐不吐而心烦，这一个，最容易传里发生太阴病了。所以到五六天的时候，这一个少阴病支持在表的时间最短，二三…二三日以后，四五日就常传里了，啊。到“五六日，自利而渴者”，自下利，而渴者属少阴也。这一个渴呀，他这一句话是这个意思，我们方才，啊，上次讲那个太阴病的时候，曾经讲过，所以“下利，不渴者属太阴，以其脏有寒故也”，是不是有这么一节啊？这一个虚寒在里，它不像热，他不渴；那么渴呢，都是有热。那么这一段，啊，所以他这是…他这个用这个字啊，他让你作这个参考的。那么也有渴属于太阴的。这一个就是。“自利”，一般说这个病于太阴，发生虚寒在里的这一种下利，他不应该渴。那么现在这个渴呢？与少阴有关系。因为少阴呐，他就是津液虚。就是津虚血少啊，啊。本来他就虚，他一下利呀，更丧失体液，所以他这个时候他渴。这一种渴他底下有注解，“虚故引水自救”。他说这个渴呀，不是里热那个渴。他就由于伶仃一传里，一下利，更使着津液虚，本来就虚。那么这个虚，他缺水呀，是吧？所以他要是引水自救，这么一种反应的渴。这个渴也不是，啊，像里头有热那渴那么厉害。所以他搁个属少阴也。所以他这个书不好讲就在这个地方，假设你前后不这么看呐，没门儿，啊，这就弄糊涂了。说是这个阴寒下利应该不渴呀，这一个怎么渴还属少阴呢？你要照字面上，这个不

能讲。他这个让你对照前面。他说这个渴呀，是虚所造成的。所以我们这辨证啊，也不能说这人下利一渴，它就是热呀！你要好好看，啊。那么这一个怎么能证明它呢？他底下就说了，“若小便色白者”，这肯定是，不是热，而是寒，虚寒，啊。这是下焦虚有寒的问题，所以说他是少阴病的渴，啊，他这虚的渴。这一个头前儿你也得，看头前儿。在太阳篇，有这么一段，大家还记得不记得？伤寒六七日不大便，头痛有热者，啊，那么可以与承气汤，但小便清者，知不在里仍在表也，宜发汗，宜桂枝汤。这一个跟那一个是一样的。那么那个真正里热，小便非红赤不可；假设小便清白，这一个病啊，啊，不是里热的问题。所以这个证…辨证啊，不要片面看问题，就在这儿，啊。那么这个渴是里热呀？是因其“虚”而渴呀？因其虚而渴，肯定这个下利是阴寒下利。那么如果因热而渴呢？又当别论了。那么这一个拿什么方法再证明它呢？所以这个疑似之间呐，你要取其它的问题了，或者以脉，或者以这个尿。尿也是验寒热的一个…一个，啊，标准呐。因为头前儿都讲过的了，所以在这儿他提…提一提。那么这个时候你看这个尿，如果红赤，肯定这个渴与阴证没关系；如果它白，啊，是下焦虚寒，也就是里…里虚寒了，啊。那么这下利是在下面嘛，啊，这属于下焦的问题呀，所以这个下利，属于这个虚寒，这是没问题的了，啊。正因为小便色白，正因为这个，啊，下焦虚有寒，啊，不能制水，啊。就说这个水呀，它与这个，正常的这一种这个包含的内容不一致，啊。你像那个…这个水的成分呐，他…他里头，你像这一个，啊，多少的有些胆汗啊，因为这个水代谢，啊，这里头这个尿素等等的，所以这色儿它不会白的。那么白的，说明…啊，这个…这个水的这个消化呀，没有…这个机能的虚衰，没有得到这个正常的消化，他是这么一个说法。这是古人的一种看法了，啊。那么总而言之，这一段很重要。第一个，啊，一般说是阴寒下利不渴；那么他渴呢，也有阴寒下利。真正虚他也渴，这种渴不甚，啊。那么你要看看他小便是黄赤

啊，还是清白。黄赤肯定这是里有热，那一个就不是…既不是少阴，也不是太阴。他不是…啊，少阴病转属太阴了。肯定这是…啊，就这以前发生是少阴病，也要转属阳明了，啊。那么他要是小便色白呢？肯定这是，上边这个断法就是对的。所以这是关于辨证的问题。所以这一个书啊，必须再整个看。一隔裂开呀，就什么也不是了。那么由于太阴病，啊，他说了。下利，啊，要是不渴的话，这都是属于阴寒下利，宜服四逆辈也，啊。那么这一个他又提一个不渴，也是一…啊，他病于太阴他怎么就不渴呢？啊，也有这个情形，那么这个人津液特别虚，缺少水分，他这么一种想水喝。那么这一个可以验之以小便，啊。这在太阳篇也讲了，所以伤寒六七日不大便，这个时候头痛有热，这肯定这是阳明。啊，他不大便嘛。但是这个也不一定啊，你看看这小便如何？如果小便赤，肯定的，啊，那用承气汤；那么小便清，就是这一个说色白了，这一类的了，啊，那肯定这是，不在里头有热，啊。那么这个脑袋痛啊，还是表证，啊，发热头痛了，那还是要解表了。所以这个书，它前后它是…啊。你必须要整个看。不然的话，你们看看这个注家这个解释都错了。他这个道理在哪儿呢？他就光瞅这一段，他就闹不清楚了。这是第二段。这一段挺重要。第一个，说明这个少阴病，要是内有停饮，是绝对要传…太阴，啊，发生这个自下利的这个病不可。也往往的，这一种下利，由于少阴病这个本虚呀，啊，容易引水自救这一种渴。不要错…错看了，你要好好辨证，啊，验个小便看怎么样。所以这一段呐，啊，很不好讲，啊。看这个本文啊，常常闹错误。

李冠杰：这个条文在《康平本》里边是降一字格排版的条文。

下面我们解读一下：

“少阴病”，指的是典型的阴性表证的症状反应，除了提纲条文里边“脉微细、但欲寐”，还应该有“发热恶寒”这一类的症状。

“欲吐不吐”和“自利”，在这儿实际上是在阴性表证的基础上，

出现了这一类症状的情况，这个跟太阳篇葛根加半夏汤属于同一类情况，只是病理基础不同。这个地方是以阴性表证为基础的，太阳篇里边的葛根加半夏汤证是以阳性表证为基础的。在这个阴性证的基础上，我们可以把它理解为，它的病理就是人体机能沉衰影响到消化系统，使消化系统陷于虚证，造成的这么一种情况。它跟葛根汤证、葛根加半夏汤证、桂枝汤证的那种机能偏于亢奋的情况下，出现的消化道内的一些症状还是不同的。事实上，阴性证里边一旦出现消化道内的一些疾病的话，病情就比较严重。换句话说，它比阳性证的危险性更大。

“心烦”，在这儿应该把它理解成是一个虚证的反应，因为虚而造成的这个人有一种虚烦不安的症状。

“但欲寐”，就是典型的阴性证的症状反应，提纲条文里边有。

“渴”也是因为虚，而造成人体对水分的吸收不足，而造成的一种人体体液的虚损。

还有一个时间的问题，“五六日”，它有两方面的意思：一个是少阴病出现下利而渴这一类的症状，多会在疾病持续一段时间后才出现，这里边就暗含了已经具有了太阴病的趋势；第二个是少阴病虽然是在两三天的时候常常就发展与其他类型的疾病，在这个时候会出现变化，但是也有维持多日还基本上保持在少阴病病理阶段的情况。

旁注“属少阴也”，又进一步明确了上边论述的这些症状反应，虽然说患少阴病已经多日了，但是本质上仍然处于少阴病，应该说这个解释是比较到位、也比较好的。

“虚故饮水自救”是对上边论述的这些情况，所做的一个病理解释。虽然阴性病已经多日了，而且还出现了“心烦”、“渴”这一类的症状，但是这些症状是少阴病的虚证的一种反应，应该要与阳性病的那种实热证加以区别。“心烦口渴”这既有点像阳性的半表半里证又有点像阳性里证。

为了进一步证明这不是阳性的里实热证的证候，也不是这种病理，条文的作者具体地论述了一个辨证的方法：“若小便色白者、少阴病形悉具”。实际上，这是这个条文论述的一个落脚点。

从上边的论述就可以看出来，不仅仅患者的表证已经多日，而且还出现了一些与阳性里证较为接近的症状反应，按照咱们以前学过的知识来看，它就有可能是发展为阳性的里证或者半表半里证，如果想进一步地确定到底是不是？实际上这个问题，绕开条文里边这些，不容易说明白。

如果是一个真正的阴性证，你要是用了治阳明病的方剂来治疗的话，那肯定有可能出现医疗事故，这是很危险的，一定要准确地把疾病的性质辨准确了，这很重要。以小便色黄与否来判断人体有没有热象，这本身是中医辨证里边一个常用的方法。一般当人体机能偏于亢奋的时候，有里热存在，小便当中代谢物就会增多，往往小便常会偏黄甚至偏黄赤；相反地，像这条条文论述的这样，人体机能偏于低下、偏于沉衰，小便中的代谢物就会减少，常会表现为小便色白。这个条文正是用这种方法来进一步确定上边的这些述症，它的疾病的属性。

实际上咱们在临床当中，客观地说，“小便色白”也不是一个绝对的，不是所有的阴性证病人中，小便都是清长的，相反地，也不是所有的阳性病人里面，这个小便都是黄赤的。因为人本身就是一个活的，动态的。阳性证不是特别严重的时候，象茵陈蒿汤证，如果人饮水多了常常也会使小便呈白色的。阴性证的喝水特别少，小便也会有一点颜色，这都是有条件的。你只要知道这个道理，想证实也非常简单。你小便怎么样啊？我小便挺清、挺白的，接着问平时喝水多么？那这个很自然的就来了。

这个地方我们应该把它看成是一个例子。前天一个同学问了一个问题，少阳病的实证是什么样的反应？热证应该是什么反应？虚证应是什么反应啊？这是在学到一定程度以后必然会有这么一个阶段。因

为这个问题很重要。我拿什么来判别一个患者，他到底是什么样一个病理状态？我如果定不了这个，我就定不了方证。那么我定它的依据是什么？是依据的症状对不对？这些症状我怎么来分别呢？我们先把这个问题放一下。

我们说一个比较容易说明白的问题。现代疾病是很实实在在的事儿，象胃炎确实是胃那个地方发了炎了，但是它表现不一样，这在中医里面，概念是不一样的。我们从另一个角度看，在很多方证里面都可能有关胃炎。比如理中汤证肯定是有了，桂枝汤证里面有，四逆汤证里面有，四逆散里面有，小柴胡汤里面有，多了去了。如果我们提这么一个问题，理中汤证的疾病都是些什么？你就会发现，把这些疾病罗列出来以后，似乎一点规律都没有，甚至里面还有包括皮肤病。怎么去理解这个疾病和理中汤证之间的关系呢？我怎么去理解啊？关于这个症状，我跟大家说过，任何一个方证，它都不是一个固定不变的症状群，它是一个动态的症状群。在这个基础上，不能简单的把它等于某某病理，一堆症状里面，一定有其它类型的疾病。像今天咱们学这个条文里面，“脉微细、但欲寐”这两个都说了吧。实际上这三阴病里面都常见。那么我怎么知道这是少阴病里的“但欲寐”呀？去看他有没有表证啊！所以许多症状放到一块儿，特别是一个人身上的症状，你放到一块儿的时候，它才有意义。一个单独的症状，常常是没有意义的。

今天学习了“心烦”，常常就会是少阳病的症状。一般是纸上谈兵地说，它是少阳病的症状，但是放在这个条文里面就不行了，你要把它理解成少阳病，那哪是啊。后面这一个小便清长，一下子就把你给否了，“心烦”的性质就变了。

如果“心烦”，抛开阴性证，一个“口苦”，一下就把这个“心烦”的性质给固定了。有一个“口苦”，或“胸胁满”，那这个肯定是少阳病了。这也就是经方理论“难”的地方。你要是问我这个，我

没办法给你罗列一堆症状，说只要是这一堆症状，套上了它就是少阳病的虚证，或者说是少阳病的热证。我很难给你说一个确切的定义。

那么我们能不能掌握？完全能掌握的。多学，多去体悟，多去感悟条文里面的论述，再去结合临床当中，慢慢就能掌握。我在整个问诊当过程中，从病人往里走的时候，门是玻璃的，一看见病人，实际上诊断就已经开始了。首先就是性别吧，年龄，然后走路，健康状况怎么样？这就有了一个基本概念了。然后再开始问诊。象这些都是下意识的，病历上是不写的。比如他走路慢慢悠悠的，有气无力的，有时候是不是也是依据啊。当然大家临床时间长了都有这种感觉，一些很容易辨的，一问“口苦，胸胁满”，其他的症状不明显，这个就没有必要过多地去推敲了。但有些复杂的病，你非得仔细地去推敲，就是再去找证据。

后面的附注：“小便白者，以下焦虚，有寒，不能制水，故令色白”。初一看，它解释得非常有条理。但是你仔细去品味，它跟经方理论是不合拍的。少阴病是人体整体机能沉衰而出现了表证。“下焦虚”是将客观上的整体疾病，主观地把它归为某一个具体的部位。因为小便是在下边解出来的嘛，所以说就把它主观的认定为下焦有问题，实际上这个小便清，不一定是单纯的下焦虚寒，人整体机能沉衰的时候，代谢物小便里面就少，就这么来的，不一定就真正是下焦的问题。

经方的理论，它不是特别注重某一个部位、某一个器官。特别是所谓的“不能治水”，它跟条文论述的病理相去就很大了，不是一回事了。如果说有这个因素的话，应该有小便频数之类的情况存在。相当于这个条文里边论述的情况，又增加了一个水证。事实上这个注解内容，它反映出了作者有将经方理论当中的少阴病，混同于《内经》理论当中的少阴经络发病，这不仅仅是有那种倾向的问题了，它本身就是想说明这么个意思。

病人脉阴阳俱紧、反汗出者、亡阳也、此属少阴、法当咽痛而复吐利、（283）少阴病、咳而下利谵语者、被火气劫故也、小便必难、以强责少阴、汗也、（284）

胡希恕：283 条：“病人脉阴阳俱紧”，这是太阳伤寒的脉，是吧？太阳伤寒呢，他是无汗。现在有汗，他所以搁个“反汗出”。那么这样子一出汗就不是太阳伤寒了。这是“亡阳也”，这是表虚不固，而津液外亡，啊。这个“亡阳”指着津液说的了。那么亡失津液，表虚，他还属于少阴，他所以说“此属少阴”。这个少阴病啊，一般说，脉是比较微细的，脉浮而微细；也有浮紧的，啊，也有。这一个就说明这一个，啊。那么这个“阴阳俱紧”，这个阳指着寸，阴指着尺。仲景这个脉法呀，这个阳有指着脉浮的，啊，这个阴有指着沉取的。你像咱们头前儿讲太阳病，啊，“阳浮而阴弱”，这个阳啊，浮于外而弱于内，这是内外为叫阴阳。那么这一个呢？不是的。这个就着这个“位”，啊，寸尺之分。那么那个…候这个表里呀，在仲景这个脉法也有两种。有以浮沉来候的，浮为表，沉为里；也有以寸尺来候的，寸以候表，尺以候里的。这一个呢，就是，所以这一个在《金匱要略》里头呀，啊，脉浮者在前，其病在…在表，啊，浮者在里，在这个，啊，关以…脉…浮在脉前，啊，浮在前就指着关脉呀；那么浮在后呢？病为在里，他以这个尺寸呐，来候表里。他这个脉法呀，所以研究仲景书，他这个脉法也得知道。他这一个就是这样子。寸也紧、尺也紧。可这一个紧呐，不是实的问题。因为什么？他汗出。不是太阳伤寒阳气重于表，不是那样子，这一个他是亡阳。“亡阳者”这是表虚不固而汗自出。那么由于这一个寸脉紧，这个紧就是邪胜，就是外邪……（音频缺如）那么这个津液又虚，所以“法当咽痛”。这一个，啊，

这个组织枯燥再一有热，他要…要嗓子要痛的。阴脉紧，他阴脉也紧，这个紧脉也主寒也主水饮呐。这个阴脉紧是里有水饮，有寒饮。那么少阴病这个尺脉紧里有寒饮，法当吐利。所以他这个“法当咽痛，而复吐利”，冲着这个“脉阴阳俱紧”说的。那么这一段也不好讲。这一段，你得把它分析清楚，啊。所以少阴病啊，也有些特殊的问题，这是说它特殊的问题。少阴病一般脉偏于“微细”呀。也有“紧”的。可是紧他与太阳伤寒是两样啊。太阳伤寒脉浮紧是表实，啊。咱们说麻黄证阳气重故也。他这一个…啊，阴阳俱紧呐，而反汗出，这是亡阳，那么他这个表气不固，而亡阳汗出，这么一种情况，所以他这个属少阴。那么为什么“法当咽痛而复吐利”呢？由于这个寸以候表，表的邪热甚，又亡失津液，所以法当咽痛。尺脉也紧，里有寒饮，法当吐利。所以既咽痛而复吐利。啊，他是这么一个。他这个文章啊，都是非常简练，啊。这是说少阴病啊，有这个特殊的这种脉应，啊，他这一个，啊，常常有这种情况。那么这一个，不是说是马上他就要…啊，这是说这个往后啊，开始这个少阴病要有这一个，啊，汗出脉紧，他这一个，所以这个紧脉，它是还是有余的脉了，他邪热盛了。这一个传内呀，也传少阳的时候多。那么这一个吐利和这个咽痛，啊，这后头有治疗，啊，这个猪肤汤就是。这一个不适于…这是，不过是虚热这一种证候，不是太阴这一种证候，这一种这个下利呀，也不是真正的太阴下利。这个咽痛呢，啊，这是近乎这个少阳病了。所以这个孔…这个孔窍的这种发炎，大概都属于少阳病了。这一个他说明呀，啊，这个少阴病要有这个脉，要是传里的话，能发生这个情况。

284 条：以火劫发汗，这是迫使大汗。少阴病，他又本虚，津液虚，这个发汗最伤失津液。那么病表的这个时…这个阶段呀，是要发汗，但是要微发汗，啊，不像太阳病。更不能用火攻。以火迫使大汗，这更错了。如果里头要有停饮的话，这个火邪激动里饮，逆于上者，啊，涉及于肺则必咳；迫于下则必下利。他这个受这个火，啊，这个

火气的这个激动里饮的话。火气入胃呢？那一定要谗语。少阴病津液本来虚，再迫使大汗出，小便必难。他没有水往下行了。那么这就什么道理呢？就是强责少阴，发汗，啊。它不应该用火劫发汗，这是强责少阴害的，啊，让他大汗出并不对的。在太阳病也不能用火攻，咱们头前儿都讲很多了。那么少阴病呢，尤其不能火攻，要火攻就有这个，啊，变化发生。这少阴病因为在表了，也是要…要用发汗呐。但是发汗更得戒之，啊。第一个他说的火攻不可。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降二字格排版的条文。

在《宋本》“法当咽痛而复吐利”之前为第 283 条，之后是第 284 条。

分别解读一下：

先看看第 283 条，这个条文论述的，实际上就是一种近似于桂枝加附子汤证的这么一种情况。

“病人脉阴阳俱紧，反汗出”，这个“脉阴阳俱紧”，指的就是表实证。病人不应该有汗出，所以这个“汗出”，用了“反”字。那么这儿呢，我们可以从另一个角度来理解他论述的这种情况。这是桂枝加附子汤证而现“阴阳俱紧”的脉。这个“紧”，不一定桂枝加附子汤证就见不到这个脉，不一定的。

“亡阳也”，为津液虚损。作者应该还有另一层意思，就是阳气不足。所以，才有后边“此属少阴”这样的论述。

“法当咽痛而复吐利”，因人体的机能偏于沉衰加之津液有所虚损，所以容易出现“咽痛和呕吐下利”这类的情况。那么，这儿的“复吐利”，实际上跟第 282 条当中论述的“欲吐不吐，自利而渴”，属于比较类似的症状反应，都是在阴性表证的病理状态下，同时出现了胃肠功能低下，所造成的。

这个条文论述的，就是少阴病如果表现为汗出并伴有呕吐和下利的时候，常常会出现“脉阴阳俱紧”，并可能因为“津液虚”而发生

“咽痛”的这种症状。

第 284 条：“少阴病，咳而下利，谵语者，被火气劫故也，小便必难，以强责少阴，汗也”。

这儿的“少阴病”，为阴性表证。

“咳而下利”，是少阴病常见的症状。在这个条文当中呢，既有被“火劫”之前就有这个症；又有被“火劫”之后这个症仍然存在的意思。这个“咳而下利”和“谵语”之间应该加一个逗号，分开读。

接下来是“谵语”，这个“谵语”本来不是少阴病的症状范畴。条文后面“被火气劫故也”，就是指的谵语这个症状，是误以火攻所致。本来是个少阴病，误以火攻，也不可能再发生阳性证。所以，这个地方的“谵语”应该与阳明的“谵语”不一样，有所区别。这个“谵语”，实际上是一种虚脱性的神昏不清而说胡话的这种情况。

“小便必难，以强责少阴，汗也”，就是少阴病误用火攻之后，因为汗出太多，而造成小便不但量少，而且小便也不容易排出。

那么，这个条文实际上论述的就是：少阴病不可用“火攻”这个方法治疗。当然，把它理解成少阴病的治疗原则，或者治疗禁忌，也可以。

少阴病、脉细沉数、病为在里、不可发汗、（285）

胡希恕：这个细数之脉呀，是虚而有热呀，啊。就是津虚热盛，脉细数。见之于沉，这是里，啊，津虚热盛的这么一种情况，病为在里。要少阴病，要是细数见于浮呢？那没问题呀，那是根据少阴病的发汗法了，啊。他脉沉，啊，沉为在里呀，这是虚热在里，这一个不可发汗。所以说少阴病，啊，那么它是个表阴证，我们说它是表证，历来注家不承认的，啊。这是我这么讲。可他不是表证，为什么这也不可发汗，那也不可发汗，这不是废话嘛！这很清楚它是个表证。是

个表证，它不能拿太阳病的发汗法子来发汗，要是微发汗才对。它后头有呀，啊！用火攻不可，尤其到已经脉沉，它这个病，啊，已经入里了，那是太阳病不能发汗，少阴病也不能发汗呐。

李冠杰：这是一个降两字格排版的条文。

要客观地理解这个条文，首先要弄清阴性表证和阴性里证的区别。由于少阴病是属于机能沉衰的疾病，常常会伴有一些像呕吐、下利这一类近似于里虚寒证的症状，这就需要跟阴性的里证来加以区别。少阴病与太阴病的区别，从病理上划分，是以表证为主要矛盾，还是以里证为主要矛盾的这个差别。但是这两者之间，有许多的症状反应是相同的。比如“发热”，四逆汤也有发热的情况，理中汤也有发热的情况；“发热恶寒”了，也都有可能出现“恶寒、肢冷”，而“但欲寐”更是共有的症状了。而它们之间的区别也是显而易见的。比如头痛、身痛、咳嗽、鼻塞流涕等等的这些表证的症状明显了，那就应该理解它是少阴病；而下利、呕吐、四肢厥冷这一类的症特别明显了，那实际上就是太阴病了，就是里证了，它是以里证为主要矛盾。

好像让人感觉不太好理解，因为在临床当中，我就曾经碰到过麻黄细辛附子汤证。老年人感冒了，出现下利，我当时就是用的麻黄细辛附子汤，同时我又预备了一剂四逆汤。他当时发烧、咳嗽很厉害，我想如果这个下去以后，下利还不好，再让他喝四逆汤。结果吃了麻黄细辛附子汤两个多小时，烧慢慢退了，也慢慢不咳嗽了，他自己也感觉肚子不咕噜了，也没有往下走的那种感觉了，实际上下利也就停止了。这就出现了刚才我们说的的问题，他有一些里虚寒的症状，到底应该是按里证治，还是按表证治？你要去辨哪一个主要矛盾。比如麻黄细辛附子汤这类方剂，细辛和附子既有温里，又祛水，特别是附子还能振兴人体的机能。一些类似于呕吐下利的症状，在它不是主要矛盾的时候，随着的表证的解除，人体自己就能恢复。所以说不能机械地套用，不能只要有一点里证、偏虚寒的就以里证为主。虽然那么

治也不会有错，不会出多大的问题，但是病程就会变得稍长一些。

“少阴病”就是指的至少得有阴性表证的一些典型的症状反应。

“脉细沉数”，客观理解这个作者的本意，他是用“脉沉”为在里，“细数”为虚，或者说还有一点点虚热在里边，这都不太重要，他想表达一种什么样的病理状态？就是一种阴性的里虚证，或者说里边还略微有一点点热的这么一种证候。

所以后边有“病为在里”。这种脉不一定真就是“病在里”，真正临床当中患者的脉，有时也不一定真就是像他说的这么具体。说凡是这类情况准现这种脉，那不一定的。对于里证，无论是里虚寒证，或者说是里虚热证，无论是哪一种为主要病理的疾病，都不可以用发汗的方法治疗。所以说“不可发汗”。

但是这个条文的作者，他在理论上有过分强调脉诊的倾向。所以说他的论述，也常带有一定的片面性。像这个条文就是一个典型的例子。这个条文只有一个症状，就是“脉细沉数”，少阴病又出现了“细沉数”的脉象，从临床的实际统计资料来看，这种脉象在少阴病的三个典型方证里边，像桂枝加附子汤证，两个麻黄剂，这种脉象都可见到。特别是在有发热的时候，尽管他是个阴性证，他一旦有体温升高的情况，常常脉象会现一种“数脉”；它本身就是阴性证，“细沉”的脉也是常见的脉。实际上这是常见的脉象，但他头里就说了，这又是一个少阴病基础上出现的一种情况。所以说这个条文，他用这种述症，做出“病为在里”的结论就不充分，片面。实际上这本身就是要把脉诊僵化，就是说“脉细沉数”，只有里证里边才可以见。事实上不是那么回事，阴性表证里边这是很常见的脉象。

如果患者确实以阴性里证为主要病理的情况下，发汗当然是禁忌了。但是条文里边仅一个少阴病和一个脉微细的话，不仅仅把它说成里证的证据不充分，就是“不可发汗”的这个结论，也相应的不充分。因为它完全可以是阴性表证，这“不可发汗”不就失去基础了吗？或

者说少阴病而见到“脉细沉数”的时候，就不可以发汗吗？实际上完全可以发汗。它只要是真正的少阴病，完全可以发汗。这个条文看起来写得很通顺、很精练，但是，它经不起推敲。

少阴病、脉微、不可发汗、亡阳故也、阳已虚、尺脉弱涩者、复不可下之、（286）少阴病、脉紧、至七八日、自下利、脉暴微、手足反温、脉紧反去者、为欲解也、虽烦、下利必自愈、（287）

胡希恕：286 条：这一句，啊，也更好，后头也有令这矛盾的事儿，我们可以接这一段，啊，将其讲了就明白了。这个少阴病这个，这个“脉微”呀，指着“脉微欲绝”那个“微”呀。不是咱们开始说是“少阴病，脉微细”那个微。那一个，浮之中偏于微细；这一个“但微”呀，“脉微欲绝”那个微呀。真正微到那个分气上，那不可发汗。什么道理呢？没有津液，“亡阳故也”。这个，啊，这个外面津液，啊，没有。不是阳气重而是亡阳。那么外边的阳已虚，这是不可发汗。尺脉要同时再弱、涩者，啊。弱，尺脉，尺以候里，我们头前儿不讲了吗，这个尺以候里，可见上边这个脉微呀，是指着阳脉微了，寸脉微了，啊，它寸以候表嘛。那么尺脉弱，里虚，涩者血不足，里虚而血不…啊，里也虚而血不足，更不可下。所以少阴病，啊，他是…要是脉微，啊，不是“微细”那个“微”，这一个“微”是微…啊，“脉微欲绝”那个“微”，脉似有似无的，这是没有阳。这样的不能发汗的。这跟上边那个都全是就这个，太阳病有发汗的禁例，少阴病呢？也有，啊。他举这么几个，啊，特别的情况。

287 条：我们头前儿不讲少阴病有脉紧的这么一个情况吗？这

个就是接着那一段，承那一段说的。那么这一个，到七八天的时候他传里了，而自下利，啊，就传里为太阴病了。原来是脉紧，这一个骤然间，脉微了，啊，“脉暴微”。可是这个时候有好有坏。如果手足逆冷，那胃气已衰了，那是坏现象了，这一个病就是了不得了，是吧？手足不逆冷，不厥，而反温，这是里气…啊，胃气相当好啊，胃气还强，那么原来脉紧，他还没有了，这是欲解之候啊。虽然烦而下利，这个“下利烦躁”这是一个，啊，不好的样子。咱们治下利，啊，这快了，热天下利的病有的是了。要是烦躁，这个病都是一个变化莫测的时候，这个病在进展。那么这一个烦呢，不是的。这一个正与邪争则烦呐，啊，虽然他烦躁而下利，不要害怕的，一定好。这一段呐，在太阴篇里头也有了，就是“腐秽当去”那个，啊，那一条互参就明白了。这个不一定得少阴病，太阳病也是一样的。这个病的邪气呀，非常的实，啊，脉紧嘛。那么传里…传里之后了，如果胃气亢盛，这个病邪呀，反倒由传里而去。所以咱们，啊，在太阴篇不有一个嘛“腐秽当去故也”。这是生理机能啊，啊，把这个病自然抗拒了，解除了就是，这很好。所以说这个中医呀，古人这一句话这是一个至理名言呐，所以“正邪交争”，这一个很合乎科学呀。古人看这个疾病啊，不是疾病自己在那儿往前进展呢。它与这个人体的这个机能啊，交互间起作用。什么，怎么个机能啊？这个生理…生理呀，就是这个，人体的这个，啊，它老跟疾病，要想解除它。就是咱们现在话就是斗争啊，啊，它与疾病老斗争，一时不息。这一个很有道理。咱们这个六经之所以形成，与这个都有关系的。我这个略略给你们解释一下子。这个人要有了病啊，啊，这人体这个东西妙计，受了外界刺激它就要抵抗。没有这个本能啊，你像咱们…这在这宇宙不容易活呀，这个病菌有的是啊。那么为什么，啊，就咱们急性传染病也是一样，他不得病，他就得病了。就是不得病那个，他就是生理机能非常的亢奋，他遇着这个东西他马上，啊，他就能抵御它。那么这个病呢，也是这样

子。有了病了，这个生理机能啊，也是想法子抗拒它，要解除它。可是这自然良能有时候它解除不了。解除不了啊，他就反应为病状了，就形成这个，这一种病状了，啊。这是咱们中医讲这一个正邪交争。你…咱们再想一想，这个人体呀，万人构造都一样啊。不是你这样儿体质，他那样儿体质，都是一样的。五脏六腑，啊，大致都…都…都一样。这个抗御疾病啊，限于这个自然的生理结构，他有一定的方面，你像咱们随便拿脑子这么想一想也这样子。人体想要排除疾病，就这么几个方面。一个从广大体表面，啊，出汗，用发汗的办法来解除疾病。咱们太阳病就是这样子，咱们也讲过了，啊，“脉浮，头项强痛而恶寒”。他就想要由广大的体表面，以发汗的机转把病邪解除。哎，他解除不了，所以这个阳气在表嘛，这个血管也多，达到一个饱满充血状态，脉紧，脉浮而紧，啊，头项，啊，那个，这个血液凝滞性那个疼痛。这个咱们都得过感冒，都有这个感觉。那么体温也高了，与外边的空气…啊，与外界的这个差距加大了，那觉着恶寒。咱们细想想，这些症状是什么呢？这还不是就是…你要看看那个解剖生理学就好了。这个人要发汗以前呐，第一个血管扩张，尤其毛细血管。所以内部的体液呀，大量输送到体表，干什么？他想出汗，毛孔一开，汗就出来了，从汗腺就出来了，那热就解除了。可是咱们一般的得感冒啊，他形成这一种，啊，太阳病的这个阶段呐，达不到汗出，这一种准备条件都…都具备了，所以这叫表证，啊。那么再有一个方面，你想想，这个人体这个构造啊，表不行，他就还想个办法，就是里。里就是消化道之里了。上面吐出，啊，下面排泄。他利用这一个，啊，道理。这也是万人具备的。咱们讲那阳明病、太阴病都是这个东西。他把这个病邪呀，整个的驱逐…驱逐在这个胃肠里，就达到这个目的就行。也是受于良能限制达不到，啊，就即便下利了，啊，他那个…他这个胃肠的机能啊，也不…反而自己出了毛病了。病邪反排不出去，自己还出了毛病了，就是所说太阴病的这一类的情况。那么反倒达不

到这个泄下的这个作用，就是阳明病的那个情况，这就是里。除去表、里而外，哎，就是利用半表半里这一方面。这一方面呢？利用一切脏腑的机能，呼吸道啊，泌尿系呀，等等的方面把它排除。这就是咱们说这口苦，咽干少阳病那种情况了。这个排除疾病，在人体上啊，只能有这么三个方面，你想想，可是这就规定一个东西呀。规定什么了？就规定疾病反应的表、里、半表半里，这么三个部位。是不是这个样子？所以咱们这个辨证，他不是表就是里，再不然就是半表半里。除之而外没有！这一个不是疾病在那儿搞的，这就是人体跟疾病，啊，他老要想解除它，这个人体到起一个主导作用啊。所以这个病啊，不离开表、里、半表半里。那么这个机制的反应，啊，要是亢奋，就是人体的机能啊，那就是阳性证，啊；要如果这个机能的反应，虚衰，这就是阴性证。那么这个病位即使有表、里、半表半里；这个证的性质的反应，不外乎两大类，一个阴一个阳。所以表有阴阳，里有阴阳，半表半里也有阴阳，就六个型，六个类型，六个基本类型。我们现在临床上还这些六个类型，他不是这个类型，就那个类型。也兴这个类型与那个类型它是交错互见，这都有的。这就是六经啊。他古人通过临床啊，他看着这么六个，六个类型。这个也是不容易呀，他经千难万困总结出来的。所以咱们这六经就是这个。可是古人呢，对于它呢，他没…没法认识，他限于当时的科学嘛，啊。我们现在比古人强的多呀，是不是？他这个条件强的多，不是…不是咱们脑袋比他强的多呀，是吧？所以他就是，哎，用上经络了。他说是经络受邪发的病，这就坏了，所以他弄一个太阳病、阳明病、少阳病都拿经络名称给你起上了。这一个是害人不浅呐，啊。但是古人也是，缘起他也未必就这个意思。可后世注家来这儿就作文章喽。这就把这个辨证的规律就弄得呀，到现在也没弄清楚。所以现在大家都研究《伤寒论》，《伤寒论》怎么个辨证的体系呀？啊，说不出来。那么中医辨证施治究其实是治疾病是治的什么呢？也不知道。你这不是…啊，这些研究中医的人，

我认为这一个，对这一方面要…要努力，是吧？中医就在这一个，它是规律性的反应，就是我们方才说，这个规律性的反应。怎么来的呢？主要来源于这个人体与疾病斗争。所以古人这一个体会是很好。不是疾病孤独的在那儿自己进展呢！它是人体与这个疾病两方面的作用。所以古人说“正邪交争”，这一个很…很…很…很科学的一句话。可惜大家都是，啊，做口头禅了，啊，没好好分析这个东西。咱们这是讲这一个，啊，扯远了，啊。可是我说这个很重要。这一个因为理解这个六经还是很重要的。那古人他是不对，不对就是不对。现在咱们有一帮人呐，对古人打掩护，我认为这一个是对的。他古人那一个没法认识呀，好几千年前。就张仲景吧，也是一千七八百年了，他怎么能认识啊？他限于当时科学水平，啊。那么他不认识不等于中医里头没东西。他这个自然规律还是好的嘛。那么他错了，我们现在还是跟着错走啊？我认为这个不对，应该解除它。我就说这个六经不是这个。不是…与这个，你们回头看看《内经》，与六经…与《内经》那个六经是根本就是一点也不相…没有相同之处。他这个都讲的表里相传，那个他讲的这个六经递传，那哪儿对？而且那一个他说是，啊，一日太阳、二日阳明、三日少阳，这三天都可以发汗，阳明也可以发汗，少阳也可以发汗。他这书不是的，少阳、阳明绝不能发汗。这怎么能共同呢？他不是共同啊。所以这个注家呀，咬定这一个经络不放，啊，这是个大问题。那么这一段呐，不光是少阴病，就是我们讲这个 287，凡是表证的时候，如果这个，啊，这个邪胜，那么它传里，传里这这也是一个生理机能啊，打算由里解除啊。那么如果“暴烦下利”，嘞，脉紧反去，而手足反温。“手足反温”这一个，啊，这是古人这个看法也对的。这个谷气不达四末，是这一个，啊，手脚冰凉，就是谷气的问题。那么温而不逆厥，说明胃气还强，那么这一个他不是一個虚脱的一个情况，这是好现象，邪去正复之象，这一个要自愈的，所以他要自愈。这个跟那个“腐秽当去”呀，啊，太阴病那是一致的

东西，可以互看。研究这个东西呀，就得想法儿，啊，怎么想法儿提高，对于中医理论的提高，这个是要紧的。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降两字格排版的条文。

在《宋本》“复不可下之”之前，是第 286 条，之后是第 287 条。

第 286 条：

“少阴病”，因为这个条文论述的这两种情况，都不是单纯的少阴病。这里的“少阴病”有阴性表证的某些证候，特别像。比如脉，舌，或者某些症状有点像少阴病。

“脉微”，这个“脉微”，在这儿应该有“脉微欲绝”的意思。你看后面不是说了嘛，“不可发汗，亡阳故也”。这儿论述的是阴性表证的同时，又伴有津液严重虚损的这么一种情况。津液虚本身就是一种类型的疾病，所以这儿不是一个单纯的表证。但是，仅从论述的脉象上来看，可能还存在着里虚寒证这一类的情况。太阳篇不是有许多不可发汗的一些条文吗？跟那儿是一样的道理。

太阳篇有好多“不可发汗”那一类的条文。实际上，那些条文都不是单纯的表证，或许有表证的某些症状反应。但是都存在有血虚证，有的是停饮证，各种情况都有。如果是单纯的表证，没有不可发汗的道理。这儿呢，我们应该理解成这是阴性证里面的一些类似的情况。

接下来“阳已虚，尺脉弱涩者，复不可下”。“阳已虚”，就说津液虚的这种情况；“尺脉弱涩”就说里虚血少，大概就这一类的，想说明有这么一种病理状态。这样，也不可使用下法。

这一段条文，纯属是无稽之谈。因为在经方理论当中，表证，无论是阴证还是阳证，都不能使用下法。何况是陷于机能沉衰的这一类的情况，更没有使用下法的可能性。所以，即使没有“阳已虚，尺脉弱涩”，阴性表证也不可以下！

下边是第 287 条：“少阴病，脉紧，至七八日，自下利，脉暴微，

手足反温，脉紧反去者，为欲解也，虽烦，下利必自止”。

这个条文跟太阴篇当中的第 278 条属于同一类的情况。都是论述阴性证在经过多日的病程以后，人体达到了一种自愈的状态，而发生的一种瞑眩反应。为什么这么去理解？他恐怕在临床当中见过类似的情况。

这个条文的大致的意思做个直译：少阴病，表现为“脉紧”的，在经过了七八天的时间之后，出现“自下利”的这种情况，并且这个脉，突然变为微脉；这个时候如果手足温，紧脉消失了，这是一种自愈的证候。虽然会出现“烦”这一类的症状，但是这个下利，会自止的。

这个条文论述的，应该是作者有这样的临床经验。我们在临床当中见到这一类情况就非常少了。就是说，得不到合理的治疗，拖了好长时间，然后人体出现自愈的这么一种机制。但是在当时，这是一种比较常见的临床现象。这种现象本身，就蕴含了人体自愈的本能，我们应该理解成这是一种本能。

虽然经方理论当中的阴性证，是人体机能偏于沉衰的疾病。但是并不等于得不到合理的治疗或者误治，就只有不断恶化的这么一个方向。

太阴篇的第 278 条和这一条，都有一个“手足温”的症状。就是人体的消化系统和循环系统，基本保持了正常的状态。也就是人体能量的来源与供给都还基本正常。随着能量不断地积累，人体便会逐渐达到自愈的临界点。那么这个时候，他就会出现条文论述的这种瞑眩状态。这是按今天的知识，对这种现象所做的解释、理解。

只是我们现在随着人类文明的发展，对人身自愈的这种本能，常常不去研究。

从这一类条文的论述看，凡是来自于临床的东西，客观地分析，里边都非常有味道。一个是，如果患者出现的不是手足温，而是“四

肢厥逆”这一类症状反应的话，就说明消化系统和循环系统的机能也同时偏于沉衰了。这个时候如果再得不到合理地治疗的话，那么愈后就不良了，这是其一。

第二，所谓的机能沉衰，我们怎么来看？往往这种沉衰的，给人感觉这是消极的、保守的、沉降的。都是人们不希望的一种状态。但是实际上，这也是人体抗御疾病的一种形式。你仔细去感悟，它也有积极的一面。积极的一面就在于，这种整体机能的低下，人体进入了低速的运转状态。这种低速的运转，可以降低人体的能量消耗，手脚都凉，身上体温低。如果这个时候，人体消化系统和循环系统还处在一种基本正常状态的情况下，这个人体的能量就会逐渐地积累，积累到一定的程度，就会达到自愈的状态，也可以自愈。

从这个意义上说，人体陷于机能沉衰，实际上也是一种自救的本能，有积极的一面。事实上人体无时无刻的不在与疾病作斗争，无时无刻不在调整自己，适应自己的生存环境。表现出来的，有时候是亢奋，有时候就会陷于沉衰。不一定沉衰都是坏事，亢奋也不一定都是好事。

少阴病下利、若利自止、恶寒而蜷卧、手足温者、可治、
(288)

胡希恕：什么叫“恶寒而蜷卧”呢？恶寒都知道了，怕冷。这个“蜷卧”就是蜷着腿，弓着腰，叫做蜷卧。这是恶寒之甚，啊。咱们就这个证候，古人的看法啊，这是阴寒至极了。就是阴虚而寒，是吧？阴寒证。那么这个少阴病，病于里而下利，就是病于太阴了。那么这个“下利止”有的时候它是好，有时候它是坏。那后头有啊，下利止还有死证呢。他无可下，啊，他那个津液脱尽了，他就没有可下了，那就是死证。那么这一个下利止，虽然恶寒而蜷卧，就像是这一个，

啊，虚寒到家了，但是手足不厥而温，跟上面一样。所以这个胃气呀，人这一个，这个胃是生之本呐。胃气存则生，胃气亡则死。有一分胃气，这人还能眨上一分的生命，啊；没有，没有就完了。他这一个就是的，手足温说明这个胃还存在，还可以治的。啊。要如果四肢厥冷，那胃气已败，他必死无疑。

李冠杰：这个条文是个降两字格排版的条文。

下面我们解读一下：

这个条文论述的是少阴病同时又出现下利的。如果下利自行停止，虽然患者表现为怕冷蜷卧等一派阴性重症的反应，但是他手足温的话，说明他胃气尚存，能量就会逐渐增加，就是可以治愈的。

这个条文论述的重点，就是他述症里边说的“恶寒而蜷卧”这一个症。虽然看似阴性证的一个重症反应，特别是还有一个“利自止”，实际上是因为下利致使这个人能量消耗太多，人有点虚了，这个抗寒的能力不足。同时，手足温又说明了胃肠功能和循环功能还基本保持一种正常的状态。这个“利自止”，不是其它条文中论述的“无物可下”的那种危象，而是有一种自愈的趋势，所以说这个治起来，也会比较容易治一些。

少阴病、恶寒而蜷、时自烦、欲去衣被者、可治、（289）

胡希恕：这接着这一节儿来的，当然是也有下利这一种情况了。这全是说明这个少阴病转入太阴，少阴病没去，可太阴病就发生了。都在这一个阶段上。这个阴病见阳则生啊。脉…这个，“时自烦欲去衣被”，外边这一个，这个情况是虚寒到家了，也是，啊，“恶寒而蜷”呐。这个“烦”，这是热象，也就是正邪相持他烦。这个“躁”就不是了，燥是乱呐，正不胜邪。咱不说这个“正邪交争”嘛，能相持的时候他烦；不能相持了，这个邪胜，正不能胜它了，那就躁，躁

者乱也。所以他这个呢，只是烦，还能相持。而且欲去衣被呀，这是…这，啊，这个热在里边呐，相当盛，啊。这个热，这一种，啊，就是这热能恢复了，是吧？那么这是个好现象，啊。这…啊，是也可治的。这都，这全从自上一条“少阴病下利”说起的。这个“少阴病下利”可以两方面来看。一方面合病，就是少阴与太阴…太阴同时发病，啊，也叫少阴病下利；第二个就是少阴病传里而发生下利，就是少阴太阴的并病，也可以叫少阴病下利。那么这个书…这个书他没明指出来呀，但是这二者俱有啊。啊，我们研究这个书啊，可以这么样子来看。无论他是合病，或者他是这个并病，只要是这么一种情况，这个病还都不要紧的，看着挺危笃，但是还能治。主要的呢，就是胃气没败。

李冠杰：这个条文也是降两字格排版的条文。

直译一下：患少阴病以后，表现为恶寒而蜷（蜷卧），但是，有时候会出现自烦的这种症状，并且有欲去衣被的这种意愿，这种情况是比较容易治愈的。

“恶寒而蜷”，是人体机能沉衰的一种症状反应。但是，又出现了自烦而且想去衣被，尽管不是老这样，只是有时候会出现这种反应。说明人体机能存在有向亢奋方向发展的这种趋势。这就跟“手足温”是一个道理，只是表现形式不同而已。人体有这种机制，治愈的几率就会比较高。

少阴中风、脉阳微阴浮者、为欲愈、（290）

胡希恕：他这个少阴中风跟指着这一个，啊，啊…跟太阳中风是一样了，啊。他这个没提伤寒，他就随便说一个。啊，中风如此，伤寒也 如此了。就是，啊，古人认为是受风邪了，啊，啊…在太阳病里头他特别提出两种治法。（音频 033 完）

【按】：脉阳微，即寸脉微，寸以候表，寸脉微为表邪已衰，脉

阴浮，即尺脉浮，为里气渐充，此为邪退正复之象，故为欲愈。

李冠杰：这也是一个降两字格排版的条文。

“少阴中风”，在这儿可以作两种解释：一个是这儿的少阴病是由太阳中风证发展而来的，这是一层意思；另一种理解，这是一种以表虚证为主要特征的一种少阴病。就是桂枝加附子汤证。

“脉阳微阴浮”，就是指的寸脉微弱，尺脉偏浮。这个阴阳在这个地方，分别代表的寸脉和尺脉。作者的本意，他是想通过这个脉象，来表述人体表证的这种病势已经有所减。寸脉微弱了，表证的病势就有所减；而这个里气较为充实，所以尺脉偏浮。所以，他说是要自愈的这么一种证候。

但是，在实际临床当中，这一类的论述，意义都不是特别大，太机械了。见到这种脉或这类情况就断定这是自己要好了，还是有点太片面了。还是应该四诊合参。这个“为欲愈”，实际上是说预后良好。但是，也不能理解成就不需要治疗了。

我去年曾经就碰到这么一个病人，他咳嗽，其他的症状都不明显，就是干咳。而且他晚上一声也不咳嗽，只是白天咳嗽。他寸脉很弱，但尺脉反倒稍微偏浮一点，感觉右手比较明显。到最后吃什么药好了呢？就给他吃的是小青龙汤加附子。也就是小青龙汤合四逆汤，或者小青龙汤合上麻黄附子细辛汤。吃几天就好了。我为什么给他这个药？他曾经给我一个很重要的信息，他睡觉的时候感觉脚凉，因为他没有别的症状，而且人还经常活动，表面看还挺健康，不是真健康。

我给大家再进一步说，这是去年的事，而今年，他又发作这个病，他这个病发作的时候，他自己说跟以前症状是一样的。他要求还喝那个药，因为他这么要求的，还是个熟人，我就给他这个药。但是我给他非常少，就给他两天的，他吃了两天说不行，不单单是没有效果，而且还加重。我说：我给你的药，没看给这么一点吗，我给你说了，你不应该吃这个药，因为你坚持要吃。他脉偏浮偏数，甚至有一点偏

大，跟以前完全不一样了，这是其一；再一个他有热象，有明显的热象，再吃那种药他肯定是不行。后来给他什么吃好了？麻杏石甘汤合上越婢汤，又合上了猪苓汤，他小便频数很明显。到后来碰见他，他说，吃完就好了。

少阴病欲解时、从子至寅上、（291）

胡希恕：（音频缺如）

李冠杰：子到寅是每天的 23 点到第二天的早晨 5 点这段时间。它说少阴病如果好的话，会在这段时间。这都靠不住，咱不细说了。

少阴病、吐利、手足不逆冷、反发热者、不死、脉不至者、灸①少阴七壮、（292）

注：“灸”《宋本》作“灸”。

胡希恕：（音频缺如）

【释】：少阴病转属太阴，呕吐、下利、手足不逆冷而反发热者，为胃气不衰，故不死。假设脉不至者，可灸少阴太溪穴七壮。

【注】：

①吐利，是少阴病并于太阴的重要标志（见太阴病提纲）。病人太阴可关系生死，但不是说必死，其预后还得看邪正交争的结果。太阴在里，是人体御病的最后一道防线，在治疗中不可不预先考虑，给予足够重视，争取防患于未然也。

②手足不厥冷，即无四肢厥逆。反发热者（参见 294 条）胃气不衰，当有治愈之机。

③脉不至者，即脉不出。在太溪穴用灸法可亢奋阳气，促其脉至

【按】在汉代时，针灸比汤液运用普遍而兴盛，一提灸少阴，一

般都能知道，故不注明穴位。本注选太溪穴系后人经验，故从之，其后世汤液盛行，针灸反衰也。

李冠杰：这个条文在《康平本》也是一个降两字格排版的条文。

“炙少阴七壮”，《宋本》是“灸少阴七壮”，《宋本》应该是对的。“炙”字和“灸”字非常接近，可能是在传抄的过程当中抄错了。

下边解读一下：

咱们把这个条文直译一下：少阴病同时出现吐利的症状，但是，没有手足逆冷，反而发热的，有这类情况的不会致人死亡。如果“脉不至”，脉摸不到了，可“灸少阴七壮”。

少阴病且现吐利，可以理解为少阴病的同时又出现了太阴病，不能说它是单纯的少阴病。

“手足不逆冷，反发热”，这个跟前几条的论述是同一个问题，都是人体正气尚存。在经方这本书里面所有的，像这儿出现一个“不死”，还有像那种“可治”，“不治”，“不可治”，“为难治”，还有“某某死证”，凡是这类的论述，顶格条文一个没有，这不是一个偶然的现象。就拿这个条文来看，这个“不死”，就作者本意而言，与那个“可治”没有质的区别。但是这里面又暗含了另一层意思，就是说这个条文论述的这种情况，如果没有“手足不逆冷，反发热”这种症状存在，那就可能是“死证”。事实上针对这类情况的方剂很多，比如白通汤、白通加猪胆汁汤、通脉四逆汤，甚至四逆汤，都适合这类的情况。可以根据具体情况，具体辨证。

这类条文都得客观地分析。说那些“不治”或是什么的，有一些是这个作者在临床当中碰到过这样的病人，没有救活，死了，或者说碰到的不是一个，他就下了这么个结论。但有时候并不一定真的不能治。所以说对这类的条文要客观地去分析它，把不符合经方理论的这一部分成分给剔除出去，确确实实是从临床当中感悟而来的这些东

西，也就是说取其精华去其糟粕，咱们从中获得最大受益。

“脉不至者”，按着经方理论这本来就是一个通脉四逆汤证之类的方证。这个作者使用的是灸法。且不说对这一类的阴性病有没有效，“脉不至”，就是情况病比较重一点，对这一类的情况，仅仅用灸法是不是可以治愈？也许能见些效或起一定的效果。这里没有说具体灸什么穴位，仅用“灸少阴七壮”的这种方法，是不是能够达到治愈这个病的目的，值得研究。既然作者这么说，应该说肯定有效。咱们在这可以理解成，对这类的情况，可以用灸法作为一种辅助的治疗手段，比较合理。但是细品的话，这个论述本身就含有某种倾向的，含有少阴经发病的这么一层意思，我们不应该这么去理解。

少阴病、八九日、一身手足尽热者、以热在膀胱、必便血也、（293）

胡希恕：（音频缺如）

【释】少阴病八九日传里而发阳明病，故一身手足尽热。由于其人便血，知为热入血室，故谓热在膀胱也。

【注】：

①少阴病，八九日常为表证传里之期，表示病已传里。少阴病，其人必虚，虚寒较重之人病在表的时间甚短，一般用不了这么多天才传里。

②一身手足尽热，知此传阳明也，为热盛于里。少阴病本虚，虚热相搏，扰动下焦的血脉，因而便血。热在膀胱，指在膀胱的部位，不是膀胱之内。

【按】热入血室，有少阳证，有阳明证。《金匱妇人产后》的第7条属阳明证，144、145条属少阳证，热入血室还有自愈证，读者可前后互参。

李冠杰：这也是一个降两字格排版的条文。

咱们先做个直译：少阴病至八九天之后，患者出现了一身手足尽热的，为热发于膀胱腑。可能会出现便血的症状。

他论述的是少阴病因为患病多日，随着人体的逐渐恢复，有向正向趋势发展的病人。致使人体机能慢慢由机能沉衰偏向于的阳性病这么一类情况。

那么，这一类的情况，在顶格条文里面很少有相关的论述。咱们在临床当中，恐怕这一类的情况见到的也不是特别多。咱们就在这儿做个参考。但是这个条文当中，以热在膀胱显然是附会少阴病为足少阴肾经发病。那么他转为阳证以后，就是足太阳膀胱的病了。所以，这个地方“热在膀胱”，就跟经方理论是相悖的。

少阴病、但厥无汗、而强发之、必动其血、未知从何道出、或从口鼻、或从目出者、是名下厥上竭、为难治、（294）
少阴病、恶寒身蜷、而利、手足逆冷者、不治、（295）

胡希恕：294 条：（音频缺如）

【释】血不充于四末则厥，故少阴病厥者必无汗，谓但厥。若强发其汗，必动其血，致口鼻出血，目出血等，其道不一。肢厥者，血本虚，上出血更使之竭，因名之为下厥上竭，为难治。

【注】

①厥者，四肢逆冷，是津虚血少，血液阳热不达于四末的缘故。少阴病多虚，若虚的厉害则可致厥，真寒而厥者定无汗。

②因厥而无汗，若强发其汗，或发汗不当而使大汗出，必动血而发血证，夺汗者亡血也。

③血出于口鼻或目，即血竭于上。本厥于下，今又血厥于上，故名曰下厥上竭。此证温之碍于血，凉之碍于厥，故为难治，但不等于不治，当知。

【按】少阴病表证亦可发汗，但四肢厥冷属真寒证者绝不可发汗，切记。本条述少阴病而肢厥者，是少阴不可发汗证之一。

自本条以下论转属太阴的死症。

295 条：（音频缺如）

【释】少阴病，恶寒身蜷，虚寒已甚。若复转属太阴而下利，是为重虚。手足逆冷者，胃气已败，故不治。

【注】

①开始为虚寒在表的少阴病，后转属为太阴病。身蜷，即蜷着手足，团身而卧。愿屈不愿伸，是恶寒相当严重的表现。

②下利，又手足逆冷，此少阴转属太阴，一派阴寒之象。胃气已败，故曰不治。

【按】少阴病维持在表的时间甚短，常二三日并于里而发太阴证，若治不及时，就有死亡的可能，这也是在太阴篇不论死证而放在少阴来讲的原因。

李冠杰：这两条在《康平本》是降两字格的排版的条文。

《宋本》中“为难治”之前是第 294 条，之后是第 295 条的内容。先看看第 294 条。这条论述的实际上也是少阴病的禁忌。

“少阴病，但厥无汗”，这实际上是典型的阴性表实证的症状反应。从临床统计资料看，阴性表证的三个典型方证，都有肢冷或手足不温的症状存在，而且出现的频率还比较高，毕竟是个阴性证嘛。

后面“而强发之”，这是条文里论述的关键点。少阴病本来就应该用发汗的方法治疗，这个无汗的表实证，或者用麻黄细辛汤或者用麻黄附子甘草汤。但这个地方它说是“而强发之”，应该指的是用“火攻”之类的发汗方法，或是以治疗阳性表证的那种方剂，应该是一个

错误的治疗。比如本来是麻黄附子甘草汤证，因为表实无汗反用了麻黄汤，这就可以认为是“强发之”。

“必动其血”，这是属于病理解释了。实际就是采用了不合理的发汗方法，致使发汗过多或者连续的发汗，一再的误治以致人体的津液严重的虚损，到了影响血分的程度。所以才可能会发生“孔窍出血”的现象，这是阴性证误治以后出现的坏病。所以，这个地方说“难治”也是客观的，治错了就治成坏病了。

第 295 条的内容：“少阴病恶寒、身蜷而利、手足逆冷者，不治”。

实际上这个地方说的症状是比较典型的。因为前面有“少阴病”，我们可以把它理解为这是少阴太阴合病，这不是又出现“下利”、手足逆冷、恶寒、身倦”这类的嘛！它说“不治”不对，这实际上可以治的，像白通汤、四逆汤、通脉四逆汤都有应用的机会。大家看看特别是通脉四逆汤那条论述里有什么啊？中医里有“格阳”的情况，说里寒外热，实际是在强调一种特殊的情况。像通脉四逆汤、四逆汤、白通汤这类的方剂，如果有表证的那是白通汤，如果没有表证的那就用通脉四逆汤完全能治。它就是“恶寒身蜷”、“手足逆冷”，再加“下利”，这就是一个不治之症吗？不对。如果真有这样一个病人死在他手里边了，这是他没学好经方，没把人救了，或者他还没有把造成人死的真正症状写出来，只能这么理解。

少阴病、吐利躁烦、四逆者死、（296）

胡希恕：（音频缺如）

【释】少阴病不解，并于太阴则上吐下利。若其人烦躁不宁，四肢逆冷者，为胃气已败，生机欲息之象，故死。

【注】吐利，少阴转属太阴的特征。曰躁烦而不曰烦躁，因躁而烦，躁多烦少，主精气欲尽。四肢厥逆，为中气沉衰，阴寒极盛，残

阳欲息之象，故死。

【按】手足逆冷是看胃气有无的关键，若于其他阴寒证病并见，则危矣。另外，手足逆冷还应辨寒热的真假。

李冠杰：这在《康平本》也是一个降两字格排版的条文。

下边解读：

这儿的“少阴病”，实际上就不是真正的少阴病，可能存在着某些少阴病的症状反应，比如一些轻微的表证。但是从述症和结论看，这应该至少是以太阴病为主要矛盾，或者这本身就是一个单纯的太阴病。

“吐利”，应该是太阴病的症状反应，而不是少阴病的伴见症。这个地方的“吐利”，就不能理解成阴性表证而出现的呕吐下利了。

“躁烦”，这是阴性证发展到最后阶段，而使患者发生躁扰不安的一种情况。

再加上后边还有“四逆”，手足厥冷，就是胃气已经衰败了。所以他就说这是不治之症。

我们可以这么理解：这一类的病人，在作者手里边，肯定至少死掉过人，这么理解就行了。他也说这种病确实是病势比较严重，应该这么客观地看。

少阴病、下利止、而头眩、时时自冒者死、（297）

胡希恕：（音频缺如）

【释】少阴病，并于太阴而下利，胃气不复，精气泄尽而利止，头眩时时昏冒者，为血虚上竭之证，必死。

【按】头眩，时时昏冒者，有似于今所谓脑贫血证。本条所述为精气虚竭所致也。

【注】此少阴病并于太阴。下利止，要辨佳恶。胃气复，利止为

佳；里虚已极，无利可下而利止为恶。本条属后者。眩为头晕、头眩者，由于吐利而津液丧失太过所致。冒为头发沉，其重者为昏冒，血虚不足以奉上也。以上都是虚脱衰竭的现象，故曰死。

【按】阳气尽者死，阴血竭者亦死，此阴阳互根之理，兹不赘述。少阴病并于太阴当虑此变也。

李冠杰：这是降两字格排版的条文。

这儿的“少阴病”，实际上也是一种以太阴病为主的阴性证。

“下利止”，从“下利止”之后的结果上看，在下利止之前的下利应该也是比较严重的下利，是下利比较甚的一个阶段。这儿“下利止”不是一种自愈的下利，而是一种无物可下了，肚子都泻空了。

这时候患者什么症状呢？就是“头眩、时时自冒”，按今天的说法就是所谓的“脑贫血”。本来就是阴性证，而且又经历了下利非常严重的阶段，最后人体已经到了无法濡养大脑正常状态的程度了。这确实是一种危象，虽然把它定为死证有点太绝对了，但这种情况确实挺重！

少阴病、四逆、恶寒而身蜷、脉不至、不烦而躁者死、

（298）

胡希恕：（音频缺如）

【释】少阴病，四逆，恶寒而身蜷者，虚寒至甚也。脉不至者，血不足而气衰也。因无热，故不烦。神欲离，故但躁。病属不治，必死。

【注】

①四逆，恶寒而身蜷，阴寒甚，虚已极也。

②脉不至，血不足，且心脏已衰竭。

③烦者，正邪争，热也。因无热，故不烦。躁者，乱也，躁动无

暂安时，只躁不烦，有阴无阳，邪盛正衰，神欲离散也。

④死，孤阴无阳也。

【按】无下利，未传太阴。波及心脏，为少阴并于厥阴。四逆，脉细欲绝者，与当归四逆汤尚可治。但若脉不至，不但血不足，心力亦大衰，尤其不烦但躁，死在顷刻也。

李冠杰：这也是一个降两字格排版的条文。

“少阴病”在这儿应该理解为：因为少阴病失治，或者说是误治而发展为这个条文所论述的这种情况，这是少阴病往恶化的方向发展几乎到了极致的这种程度。

“四逆”，四肢厥冷；“恶寒而身蜷”，恶寒特别重，喜欢躺在被窝里边蜷蜷着，脉也摸不到了。患者不单单是四肢厥冷，恶寒蜷卧，而且脉也没了。这就说明胃气也衰败了，而且整个的循环系统也已经非常微弱了。

“不烦而躁”，论述的挺精道。把“烦”跟“躁”区别开来，他为的是要说明，这个时候患者已经处于一种神志不清、躁扰不宁的那种状态了。把烦单独列出来，跟躁分开，就是“烦”本身还有一种神志清醒的因素在里边，但是“躁”就不行了，连“烦”的那种神志清醒也没了，这实际上对比其它的，可以说这是比较重的一个，这就等于人到了弥留之际的那个状态。

少阴病、六七日、息高者死、（299）

胡希恕：（音频缺如）

【释】少阴病六七日，已传入厥阴，若气促而息高者，为气脱于上。此大凶侯，主死。

【注】

①少阴病六七日，传半表半里厥阴之期。

②息高者，呼吸短促而声音很高。气息出入全在胸上位，吸浅呼急，形容呼吸困难，竭尽全力的状态，为气脱于上的凶候，故主死。

【按】此亦为少阴并于厥阴之死状。上条为心衰，本条为气脱。两条均无太阴病特征，故知系少阴厥阴并病也。

李冠杰：这也是一个降两字格排版的条文。

那么这儿的“少阴病”，应该理解为由少阴病发展而来的，也是一个少阴病向恶化方向发展，最终一个不良的后果。

那么发展了六七天，应该理解为经过多日了。

“息高”，就是患阴性证多日，人体本来就比较虚弱。要不然，仅仅少阴病几天的时间也不会到了如此严重的地步。可能这个人本来身体素虚，他又没有得到合理的治疗，而致这个疾病最终发展到比较危重的程度。这个“息高”，就是这个人有点呼吸浅，说得更严重些，“息高”有点像老百姓说的那个“倒气”。要真是到了“倒气”那个程度，那是真的没治了，就是一个死证。

少阴病、脉微细沉、但欲卧、汗出不烦、自欲吐、至五六日自利、复烦躁、不得卧寐者死、（300）

胡希恕：（音频缺如）

【释】脉微细，但欲寐，为少阴病本有的脉和证。始得之病在表，宜服麻黄附子细辛汤。微细之脉见于沉，可知为寒饮在里。汗出不烦者，暗示原来还有发热心烦，因服过麻黄附子细辛汤，汗后表解而烦亦去也。寒饮未除，故自欲吐。太阴病的为证渐显，急与附子汤温中逐饮或可得治。待至五六日，终因胃虚无力收摄而自下利。复烦躁，以至不得寐者，是生机欲息，难得暂安之象，故终不免于死。

【按】少阴病本虚，若里有水饮，势必转属太阴。其过程由渐至著，先有自欲吐，而后自利、烦躁不得卧。通过这条正告医者，要知

防微杜渐也。学者宜与后之麻黄附子细辛汤、附子汤、四逆汤条互参而细研之。

【注】

①微细，少阴脉。但欲卧，少阴证。脉不浮而见沉者，里有寒饮。此少阴病里有水饮者也。

②此亡阳激动里饮的反映。少阴病始得之，有发热而烦者（参见309）。服药后，得微汗而热除烦去，以有里饮，虽热除烦去而病未已，反自欲吐。脉沉为寒饮在里的确证，此少阴并于太阴之始也。从另一个角度看，不烦为无热扰，反映气已不足。汗出促使阳热欲息，不是好现象。

③至五六日，或因误治，或因未治，或因人甚虚，终于并发太阴下利，乃至烦躁，既不得卧又不得寐，此正不胜邪，生机欲息之象，故死。

【按】少阴病传里为里阴证（太阴病）或半表半里的阴证（厥阴病），有可治者，有不可治者。以上六条均为少阴转属太阴或厥阴的死证，确属危险凶殆，学者宜细观熟记。吐利为表证传里的见证，宜把握阴阳属性。又阴性病入里时传变迅速，不可等闲观之。

自开始至此，可作为少阴病篇的总论。少阴病与太阳病同在表位而阴阳两种不同的证，历来注家误于经络名称，不承认少阴病亦属表，但以上有三条论述少阴病不可发汗，如不是病在表，列这些禁汗条岂不是废话。少阴病本虚，维持在表的时间甚短，二三日即常传里或半表半里，传里多属太阴，传半表半里多属厥阴。此与太阳病传里多属阳明，传半表半里多属少阳者正好相反。少阴病在表本无死证，其死证均于太阴或厥阴时见之，最后诸条乃其例也。具体证治论述于后。

李冠杰：这个条文在《康平本》也是降两字格排版的条文。

解读一下：

“少阴病、脉微细沉、但欲卧”，这是初得少阴病时候的病情。

“汗出不烦、自欲吐”，因为在后边的条文里边有“复烦躁”的明文。所以这儿的“汗出不烦”，是指之前有烦的症状，服发汗药得汗出以后，不烦了。这个烦的症状随着汗出之后消失了。“自欲吐”，说明发汗不得法，他又出现别的症状，出现里证了。这就是发汗不得法，虽然烦的症状消失了，但是又出现了新的变证。

“至五六日自利，复烦躁，不得卧寐”，这个“复烦躁”就说明原来就有烦躁，又开始发生烦躁了，以前的时候就有，后来消失了，现在又出现了。就是上述的情况没有得到合理的治疗，一直发展到五六天的时候，这个病情加重的这么一种情况。这个“自利”说明不单单是有里饮，而且胃肠功能也已经有衰败的这种情况。这个时候，人不单单是又出现了烦躁，而且还“不得卧寐”。不单说明烦躁的程度，烦躁得都躺不下了，说明病势发展非常得迅疾。所以这类情况也属于不治之症，就是也得死。

少阴病、始得之、反发热脉沉者、麻黄细辛附子汤主之、

(301)

麻黄二两去节 细辛二两 附子一枚炮去皮破八片

右三味、以水一斗、先煮麻黄、减二升、去上沫、内诸药、煮取三升、去滓、温服一升、日三服、

胡希恕：（音频缺如）

【释】少阴病以不发热为常，始得之病在表，脉亦不当沉。今反发热而脉沉，发热为邪在表，沉为寒饮在里，故以解表而兼温中逐饮的麻黄附子细辛汤主之。

【按】太阳篇谓“发热而恶寒者，发于阳也。无热恶寒者，发于阴也”。故少阴病以不发热为常。脉沉主里有寒饮，本不宜发汗，今

以始得之反发热，则表邪明显，故以两解表里的麻黄附子细辛汤主之。

《金匱》曰：脉得诸沉，当责有水。水在里者，热反外郁，此少阴病始得之所以反发热脉沉也。麻黄附子细辛汤，解表兼逐饮也。

【注】

①反发热脉沉中间不当断句。反字贯彻发热脉沉两者。少阴病本虚，以不发热为常。病在表，脉当见浮，发热、脉沉均不寻常，故曰反。脉沉，当责里有水饮。反发热的原因有二：一是邪在表，其人抗病能力较强；二是里有水饮。此亦同表阳证邪在表、里有水饮者，单纯发汗不但表邪不去，且激动里饮而生变证，小青龙汤证即其例也。不管是表阳证，还是表阴证里有水饮者，必须解表逐饮同时实施。若是表阳证，先解表后逐饮，即有变证，尚容时调整方证。若表阴证，解表逐饮分步治之则不可轻视也，必须同治。盖虚寒之人里有水饮，并于里则转太阴病之下利也。

②得少阴病的人本来就虚（津虚血少），即使用发汗药解表，也得减轻麻黄的用量以小发其汗，且必加亢奋药。若里有水饮，必加逐饮药以两解表里。本方附子细辛正为此而设，故曰“麻黄附子细辛汤”主之。

【按】本条为少阴病兼里有水饮者，乃变治方剂，下条才是少阴病的正治方剂。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格排版的条文。

解读一下：

“少阴病、始得之”，是指少阴病初发。

“反发热脉沉者”，少阴病虽然也是表证，但是因为属于机能沉衰的阴性证，相比阳性证出现发热的几率明显得偏低，所以这儿用了一个“反”字。但是并不等于所有的少阴病都不发热，不仅仅有发热，有时还会有高热。麻黄细辛附子汤这个方证实际上在临床中就常常会伴有发热，而且发热还常常会出现在发病的初期。

事实上，凡是表证，不管是阴性还是阳性的，都有可能出现发热的症状，但相比阳性证来说，阴性证发热的几率偏低一些。这条论述得就非常的简略，除了“发热、脉沉”之外，其它的症状反应实际上都隐含在方剂和条文前边的少阴病中。这个“发热、脉沉”是麻黄细辛附子汤的一个比较突出的症状，特别是阴性证在初发病时有这种表现，在少阴病里这是比较突出的、典型的症状。所以条文里仅仅论述了这两个症，其它的虽然没有论，如果我们整体解读的话里边都有，其中不仅仅包括了少阴病提纲条文论述的“脉微细、但欲寐”。“脉微细”跟第 301 条里的“脉沉”结合到一块，就是这个方证一个比较典型的脉象。虽然不仅仅就现这一种脉，但是又沉又微细的脉是比较典型的一种。因为少阴病是表证里的阴性证，所以少阴病里还应该包括阳性表证一些类同的症状，比如阳性证里的脉浮在阴性表证里比较少，但其它的一些阳性表证症状常会在阴性表证里出现，实际临床统计资料也说明了这点。在临床中本方证出现频率最高的症状依次是：精神不振、身体疼痛、恶寒肢冷、发热、咳嗽这类的症状。那么其中的“精神不振、肢冷（‘肢冷’实际上就是四肢厥冷的轻症）”是典型的阴性证的症状反应，“头痛、恶寒、发热、咳嗽”这些都是典型的表证的症状反应，在阳性表证里也是比较典型的症状反应。

麻黄细辛附子汤证的脉象：是以沉细、沉紧、沉微、沉细紧等脉象为主，这明显的跟阳性表证的脉象就区别开来了。

从这个方证的实际临床表现，结合本条文的论述，我们会体悟到经方的一些论述特点，像“脉微细、但欲寐”，因为在提纲条文里有所论述，所以在这里就给省略了。实际上“脉微细、但欲寐”在本方证里也是一个典型的症状反应，但是条文里没有论述，而表证的症状反应因为在太阳篇有所论述，所以提纲条文里也给省略了，到最终论述麻黄细辛附子汤证时就只剩下了“始得之、反发热脉沉者”这个简单的症状。虽然论述非常简单，但是按照条文之间的内在联系整体地

解读，就会发现实际上条文是很丰满的，论述的内容应该是很丰富的。但是单纯的从字面上来看条文，显得论述得特别的简。所以，我们学习不仅仅要把条文之间的联系性整体地解读出来，而且还要拿临床的统计资料来佐证。

麻黄附子细辛汤证的病理：阴性表实证合并里虚寒合并水实证。这个水证只能从方剂的药物组成上反映出来，因为方子里有细辛。

做个小结：少阴病初得病反而出现了“发热、脉沉”等症状的，为麻黄细辛附子汤主治之证。

下边看看方剂：

麻黄附子细辛汤一共有三味药：麻黄用来发汗解表，细辛是温中祛饮通络，附子有振兴人体机能的作用。需要强调的是这个方剂里细辛的作用，它起到一个非常重要的作用，要去体悟细辛在方剂中的作用，必须把这个方剂和麻黄附子甘草汤证治疗的现代病比较一下，就会发现这个方剂的应用面特别得宽，有很多我们认为解表剂不能治的疾病记录。结合这个方剂的临床应用，会发现这个方剂治疗的现代病中，除了一些感冒、肺炎之类的表证之外，还有一些像遗尿、乳房结节、暴哑、暴盲、多发性肌肉深部脓肿、脓毒血症、化脓性踝关节炎、化脓性淋巴结炎、三叉神经痛等比较特殊的病。虽然不是说这个方子就专治这类病，是说它主要的症状反应适合这个方剂，才能用麻黄细辛附子汤治好。

虽然它在这个普遍规律之内没有什么特殊性，但是这类的疾病出现在其他方证中的机会比这个方剂要少很多。这说明当人体处于这个方证的病理条件下，容易发生这类的疾病。比如麻黄汤、小青龙汤、麻黄附子甘草汤药物组成都跟它比较接近，但是却很少有治疗这些疾病的统计。好多像化脓性关节炎之类的，实际上它就是因为肢体的组织循环状态不良，它至少有这方面的因素，另外可能存在着停饮的问题，对体表的营养输布有严重的影响，这个方剂恰恰就能改善这类的

病理状态。方剂中细辛起到的这个作用的比较大，当然仅细辛也不行，三味药整体的力量才能解决这类的问题。

看看这个方证的表现症状：精神不振、头身痛、恶寒肢冷、发热咳嗽。还有一些是辅助证，像小便清长、女性带下清稀、腰酸痛、哮喘痰凝这类的症状，出现的频率也比较高。

舌象：淡舌出现的频率最高，其次是胖嫩舌、暗舌、淡红舌、红舌，边有瘀点的这类的舌象。

舌苔：以薄白苔出现的频率最高，其次是白滑苔、白苔、白腻苔、苔干，少数的还表现为苔比较干的情况。

脉象：沉细的脉最多，比其它的脉象明显得多。在 295 例医案中统计到的沉细脉为 85 例，沉紧脉只有 23 例，沉脉 20 例，沉迟的脉 16 例，沉微的脉 15 例。明显沉细的脉出现的频率高于其他的脉象。像这类的方证，包括前边学习过的大承气汤的方证，实际上都不是一种脉象。这个方证跟条文的关系，非常能够说明问题，条文里边说了一个脉沉，在提纲条文里有一个脉细，把“脉微细”跟“脉沉”加到一块儿，它不就是一个沉细的脉嘛！再看看临床统计里，确确实实它表现频率非常高。即使这样，也不等于说这个方证仅限这一种脉。但只有这样解读，才是一种比较客观的态度，最终得到的才是全面的认识。

我通过与大家共同学习，不断的整理资料，我发现其实有一些方子非常得好。但是因为在解读条文的时候“死于句下”，造成在临床中好的方子很少去用。特别像栀子豉汤系列方剂里有好些个，比如栀子干姜汤，它就是治栀子豉汤证又伴有下利的情况，但就是因为条文里说，凡病人旧微溏的不可用栀子豉类的方剂，造成了很多人在临床中就找别的方子去了。实际上在经方里，好多方子都受到一些条文的误导，像后边的麻黄附子甘草汤，论述的几乎没有证，临床中统计到的医案就不多，实际上它应该是一个典型的少阴病的方证。

这个方剂的现代应用涵盖的疾病谱非常宽：感冒、流感、哮喘、慢性支气管炎、支气管哮喘、百日咳、肺炎、肺气肿、肺气肿合并感染、肺胀、间质性肺炎、自发性气胸、心脏病、病窦综合征、冠心病、右束支传导阻滞、心律失常性冠心病、病毒性心肌炎后遗症、风心病房颤并发循环障碍、窦性心动过速、高血压、低血压、急性肾炎、慢性肾炎、肾绞痛、肾积水、遗尿、淋病、坐骨神经痛、三叉神经痛、血管神经性头痛、神经性头痛、肋间神经痛、肌肉神经痛、心动过缓、关节炎、关节风湿病、麻疹、牙痛、咽痛、慢性肥厚性咽炎、暴哑、暴盲、久咳、血管神经性浮肿、肾炎水肿、腰痛、过敏性鼻炎、周围性面神经麻痹、面瘫、发作性运动神经麻痹、四肢疼痛、多发性肌肉深部脓肿、脓毒血症、化脓性踝关节炎、急性骨髓炎、化脓性淋巴结炎、腰肌劳损、腰肌炎、骨质增生、肥大性关节炎、类风湿性关节炎、血栓闭塞性脉管炎、荨麻疹、全身奇痒症、带状疱疹、皮肤瘙痒症、乳房结节、乳腺炎、乳房胀痛、慢性盆腔炎、带下。

另外，统计资料里还有一些属于中医里的病证：像高热无汗、前额疼痛、寒痹、脚挛急、脚跟痛（脚跟痛也是一个多发病，如果见于少阴病有应用这个方剂的机会）、阳痿。

少阴病、得之二三日、麻黄附子甘草汤、微发汗、（注）

以二三日无里证① • 故微发汗也 • （302）

注：“以二三日无里证”《宋本》作“以二三日无证”。

麻黄二两去节 甘草二两炙 附子一枚炮去皮破八片

右三味、以水七升、先煮麻黄、一两沸、去上沫、内诸药、煮取三升、去滓、温服一升、日三服、

胡希恕：（音频缺如）

【释】少阴病得之两三日，以不传里而无里证为常，宜麻黄附子

甘草汤微发汗以解表。

【按】二三日无里证，说明少阴证本是表证。以其本虚，维持在表的时间甚短，四五日即常传里，并发呕吐下利的太阴病。若胃气衰败，则死也。外感而现少阴病，宜抓紧时间治疗，稍有疏忽，极易转属太阴或厥阴而致死。

由上条脉沉而用麻黄附子细辛汤可知，本条脉不沉。本方为少阴病发汗主方，亦即伤寒无汗者的发汗剂。若中风汗自出的少阴病，当于桂枝加附子汤类求之，已详于太阳病篇，故不重出。本条告人少阴病本是表证，以其多虚，传变较速，很快传里或半表半里，因此把少阴病看成里证是不对的。

【注】

①少阴病津虚血少，即使发汗亦不可大汗，同时应加亢奋药。麻黄附子甘草汤乃治少阴病的基础方（主方），与太阳病发汗有麻黄甘草汤、桂枝甘草汤一样。太阳篇 21 条“其人恶风，汗漏不止”，以桂枝加附子汤治之，其实也是少阴病，前后互参自明。

②病仍在表，故可微发汗解之。若病以传里，并发太阴病，则不可再用汗法，急当救里矣。此为定法，需切记。（可与 92 条注互参）

【按】由此可知，少阴病脉微细当为浮而微细，因浮以应表也。

李冠杰：这是一个顶格排版的条文。

方后的附注“以二三日无里证”，在《宋本》当中是“以二三日无证”，但是在《玉函经》和《注解伤寒论》里边都是“无里证”，《宋本》这个地方肯定是错了，但是到底是漏抄还是什么，咱们最后也简单地分析一下。

下边咱们解读一下：

“少阴病”，就是指的典型的阴性表证而言，这个方证是阴性表实证。跟读上一条条文一样的读法，这也包括了少阴病提纲论述的“脉微细但欲寐”等阴性证典型的症状反应，同时也应该包括太阳病里面

论述过的除了典型的阳性病以外的表证的这一部分症状反应。和我们刚学过的第 301 条比较，这个地方没有特别强调脉沉，但是从临床统计资料来看，这个方证出现脉沉的比例也是比较高的，相对不如麻黄细辛附子汤出现的频率那么高。这才是胡老说的那种典型的阴性表证的“脉微细”，但是时常还会表现为一种至少不是明显的浮脉，或者说不现浮象但也不是明显的那么沉，甚至现浮象也是完全有可能出现的。

接下来，“得之二三日”，这说明病势并不是特别严重，就是一般的阴性表证；另一方面，它暗示一般少阴病要是发展为其他类型的疾病的话，通常也需要经历几天的时间，而这里至少是二三日之前还没有。

这个条文论述得更简，就没有述症，结合“二三日”之后的条文来看，这个条文很可能有缺失，不完整。为什么？大家看后边“麻黄附子甘草汤、微发汗”，字面的意思是明确的，“微发汗”应该是指服药以后的护理上，应该是一个注意事项。因为患少阴病，人体就处于一种机能偏于沉衰的状态，发汗太过的话就容易出现变证。另外单从字面上也能看出这个地方有不通顺的意味。经方理论里边凡说方剂的应用，有“与”、“可与”、“宜”某某方剂，更多的是某某方“主之”，但是这个条文只是一个单纯的方名，而且方名之后，又加了一个服药后注意事项。像这样的论述方式，在经方理论里边非常罕见。

后面注解内容，更显示出这个作者觉得论述的文字上都不通畅，特别是嵌注内容。凡是顶格排版的条文，出现嵌注或者后边有附注的地方，你仔细去品一品，原文总是有衔接不太好的痕迹。我们今天已经不知道原书是什么样子的了，就算是当时加注的这些人，看到的那个书恐怕也是经过了若干次传抄的，他们也没有看到它原始的样子，于是在解读的过程当中感觉到不太对头，加了注解，常常是在这种情况下出的。这是我个人在反复学习当中的一种感觉。

后边的附注“以二三日无里证，故微发汗也”，也非常耐人寻味。从内容看，这显然是对“麻黄附子甘草汤、微发汗”这段文字所做的注解。原因就是那个注解的作者很可能看出了这个地方有点不通顺，才加了一个注解。它不符合经方理论在论述条文的常规规范。还有一个问题，就是“以二三日无里证”在《康平本》、《玉函经》、《注解伤寒论》这三个版本里边都是这个样子，唯有《宋本》当中没有其中的“里”字。这有两种可能性：一种是漏抄了，这种可能性不大。这个地方漏抄了的话，太不通顺了，但是我们也不能排除。第二种可能性比较大，就是有意地把它改掉了。这里面就是必有原因的，说明删改者必定认为少阴病并不是阴性表证，而是一种里证，而这里再说“无里证”就不通了，干脆把“里”字去掉。究其原因，实际上还是受内经理论的影响，拿它当经络说，这是心肾经络的病，所以说怎么能认为它是表证呢？有这种可能性。这是我个人的一个体悟。

麻黄附子甘草汤的病理非常简单，跟麻黄汤证和桂枝汤证一样，麻黄汤证的病理是阳性表实证，桂枝汤证是阳性表虚证，麻黄附子甘草汤证就是阴性的表实证。

下面做个小结：少阴病，得病二三天时间，为麻黄附子甘草汤的主治之证，并要注意微微发汗即可。

这个条文读起来，加上我们的总结，把它译成今天的白话，还是感觉它给人不完整的感受。

这个方剂由三味药物组成：麻黄、甘草、附子，麻黄肯定是发汗解表了，附子振兴人体机能，甘草是补中缓急。它可以看做是麻黄汤去桂枝、杏仁，加上附子，因为它们在治疗方向上是一样的，就差一个机能沉衰和机能偏于亢奋。所以说这个方剂即有解表的功能，发汗的力量比麻黄汤轻，因为这里面没有桂枝，同时用的量也小，这也能看出来古人在这方面分寸把握得非常的到位。

这个方剂还可以把它视为是：甘草麻黄汤加了附子（从药味上看

是这样)。在这个方证的病理状态下(也就是在这个方证的基础上),同时又出现体表停饮的情况,对这一类的治疗效果比较好。比如水肿:我这儿的医院有个护士长,她人是虚胖,曾经得过肾炎,长期浮肿。我给她这个方剂,她吃了以后感觉效果很好。

这个方子在临床中,实际应用的机会本来就比麻黄细辛附子汤应用的机会少一些,再加上条文里面论述的几乎没有证,所以在临床应用当中也受到一定影响,统计到的数据也比较少,一共有4例。因为数据这么少,就很难把它当做一个标准,去做为我们临床其中的一个尺度。去衡量临床应用,有时候就不太准确。但是,方向也不会有多么大的出入。

症状:表现最多的是肢冷,再就是面色白,另外就是便溏,恶寒、头痛、咳痰。

舌质:舌质表现为“淡舌”,就统计到这个舌象。

舌苔:有白苔、黄苔、薄苔、厚苔、腻苔。

脉象:沉脉表现最多(有3例),另外是细脉、迟脉、微脉,大家看,这个脉象跟少阴病提纲里面的脉象,也还是比较接近的。

因为统计到的资料少,涉及到的现代病也不是很多,像感冒,长期感冒难愈的,象急性肾炎、慢性肾炎、肺心病浮肿、水肿病、肺源性心脏病、心律失常性冠心病、病态窦房结综合征、心律不齐、心动过缓、风湿性关节炎、咽痛、喉痹。

少阴病、得之二三日以上、心中烦不得卧者^①、黄连阿胶汤主之、(303)

注:《宋本》无“者”字。

黄连四两 黄芩二两 芍药二两 鸡子黄二枚 阿胶三两

一云三挺

右五味、以水六升、先煮三物、取二升、去滓、内胶烊尽、小冷、内鸡子黄、搅令相得、温服七合、日三服、

胡希恕：（音频缺如）

【释】少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得安卧入睡者，病已传半表半里而为少阴少阳并病，故作虚烦，宜黄连阿胶汤主之。

【按】少阴病传半表半里，以厥阴为常，然亦间有传少阳者，今于二三日以上转属少阳。以其本虚，上焦复有热故使心中烦，不得眠也，黄连阿胶汤主之。

【注】

①二三日以上，指四五日或五六日言，为内传之期。

②心中烦，乃上焦胸中有热扰。不得卧，乃血虚烦甚，不得安卧入睡也。栀子豉汤证是下后里已不实，但有热扰心胸，为虚烦不得眠，不是真正的虚烦，而是偏于热也。本方证则是真正的虚证，又有热扰心胸，可见是真虚烦不得眠也。

③病由少阴表证传半表半里，因虚而有热，即使传少阳也不显柴胡证。这与由太阳传少阳常显柴胡证者显然有别，故以黄连阿胶汤主之。

【胡老按】下利腹痛、便脓血、血便、咯血以及吐血等诸失血证，凡心中烦不得眠者，用本方均有验。本方治心中烦不得卧，颇似栀子豉汤证，但本方偏于治虚烦不眠兼有以上诸血证者，栀子豉汤则无此功效。

【按】本方证为少阳方证，而非少阴方证。冠以少阴病，乃始得之的为证。

李冠杰：这个条文在《康平本》是顶格排版的条文。

这儿《康平本》跟《宋本》多少有一点出入，“心中烦、不得卧者”，《宋本》没有这个“者”字。

解读一下：

“少阴病，得之二三日以上”，就是这个方证是由少阴病发展而来的。但是在实际临床当中，真正由阴性表证发展为“黄连阿胶汤证”的，这类情况不多。反而是因为精神方面受了刺激，而引起这一类疾病的，倒是比较多。回到临床当中，再去对一对，有多少黄连阿胶汤证是从患了感冒又得的？要不是这样得的，就不能用这个方证啊！而且大部分都不是。所以，应该客观地来解读。

那么“心中烦，不得卧”，这是两个症状。但是这两个症状互相之间存在着密切的关联性。因为“心中烦”，就是“不得卧”的一个重要原因，烦得厉害了，就躺不住了。那么“不得卧”，反过来又是“心中烦”严重程度的佐证，或者具体的表现。那么“心中烦，不得卧”，在阳明病里面就常出现；或者栀子豉汤证，也会出现。但是，这个方证的“心中烦，不得卧”，跟其他的方证都有所不同：一个是“心烦”的程度非常严重。患者常说：“我觉得还不如死了好呢”。再一个就是大部分这个方证的患者都有严重的失眠症。

我就曾经遇到过这么一个患者，还不到30岁，她呢，整个发病的过程和这个临床表现，就跟现在学习的非常吻合。她老公出了车祸，把腿给伤着了，在医院里面住了一个多月。她呢，就是天天没黑没白的在医院里边伺候他。结果回到家以后，就生了这么一个病——失眠，连续一个多月。她见了，跟我说，我觉得烦啊，还不如死了好呢。另外一句话就是，我这一个多月了，差不多没合过眼，根本就睡不着。因为她症状比较典型，我就给她黄连阿胶汤，给了她三天的药量。她第一天晚上吃的，第二天下午她给我打电话，她说，我昨天晚上吃了一次，今天早晨吃了一次，中午我觉得稍微有点困倦了，但是我躺了一会没睡着。你能不能给我这药里多加一点安眠的药啊？我就跟她说：中药治睡眠不是西药那样，只有去了你的病，才能使你入睡。她到了第三天又给我打电话，她说我昨天晚上能睡着了，但是睡着还不如睡不着呢，那梦啊，一个接一个。因为她身体欠得太多了，太疲劳

了，再加上还没有完全进入状态，是一种似睡非睡那种状态，但是能睡着了。第四天再没给我打电话，直到一个星期以后，她来给我送钱，就跟我说，我已经彻底好了，我真没想到就吃了这么一点药就好了。我给她是粉剂，让她先用粉剂泡药，然后把药液倒出来，再往里面放鸡蛋黄。

但是，这个方证的症状反应比条文里边论述的还要复杂得多。不过出现频率最高的，恰恰就是条文里边列举的这两个证。这个条文列举的，就是一些典型的症状反应。

这个方证统计到了 144 个医案，有“心烦”的，共有 118 个，出现频率相当高了。但是也不是所有患者都必见这一个症状，毕竟还有这一类的症状不明显的。问题的关键是这二个症，不仅仅出现频率高，而且还能准确反映出这个方证的病理特征。所以我们读条文应该这么来理解。

这个方证的病理：阳性的半表半里的虚热证合并血虚证。

而这个条文论述的这两个症，恰恰是这种病理的反映。这个“心烦和失眠”，在半表半里证出现的几率都是比较高的，是一个常见的症状。但是这个方证，有血虚的因素存在。所以这个虚热证的反应程度，比一般的半表半里证要严重得多。除了这两个典型的症状反应之外，在临床当中黄连阿胶汤证还常伴有其他一些相应的症状：发热、口干渴、头晕、目眩这一类的症状，这是临床统计资料显示出来的。

我们这个地方再延伸一下：在经方辨证体系里边，这个方证的病理要素，具有相对的稳定性。这个病理要素是半表半里的虚热证合并血虚证。但是半表半里的虚热证合并血虚证，并不一定就仅仅是这个方证，下边还得要辨方证。这个方证典型的症状反应在临床当中出现的频率很高，也非常集中。既然是这样，不是 100%的病理都出现这个，那么，其他的症状，我怎么能辨出是这个方证呢？那么你再看看是不是这种病理。先辨清了病理，你再去比较一下其他的方证，如果

其他的方证概括不了，可这个方证全能概括，那就是这个方证，这就是一个排除法。

我们刚才跟大家介绍了这个临床统计资料当中，有一些不典型的证状，这些不典型的症状，包括典型症状在内，有时候会与猪苓汤比较接近。跟猪苓汤比较一下：黄连阿胶汤证与猪苓汤证，都属于热证，都有热。所以，有一些症状反应倒是有许多重合点。这个方证除了刚才说的那些症状之外，还有尿急、尿频、尿涩痛、尿血、心烦、失眠这一类的症状。这一类的症状，再去看看猪苓汤证，完全都是重合的，猪苓汤证里边也有。那么，假设一个黄连阿胶汤证患者，恰恰就是以这几个症状为主要的症状反应，反倒失眠什么的不重。你怎么知道应该用黄连阿胶汤来治呢，这不是一个猪苓汤证吗？实际上，区别这两个方证，在再高一点的层面，从病理上去区别一下，就豁然开朗。实际上非常简单，它们的区别是一个有水证一个没有水证。这不是病理上吗？只要在病理上想到了这一点，你再按照病理要素再去辨一下，就会发现，猪苓汤证和黄连阿胶汤证相差还是比较远的。别看尿频尿急那样的，但是从尿的量上，或者有没有浮肿，或者有没有尿血。猪苓汤证还有一些水证的特征，这个马上就能清楚了。

下边做个小结：少阴病，得病两三天以上，心中烦而不得卧的，为黄连阿胶汤的主治之证。

下边看看方剂，这个方子有五味药组成：黄连、黄芩、芍药、鸡子黄和阿胶。黄连黄芩清半表半里之热，除烦，并同时可以治疗因热而造成的一些出血症；那么芍药、阿胶、鸡子黄补血虚。阿胶同时有止血的作用；鸡子黄有一定的补益作用。所以，这个方剂不仅可以治疗这个条文的主要的症状反应和诸多的半表半里的虚热证，如果在这个病理上出现了便血、咯血，就是一些出血证吧，都有比较好的疗效。当然前提条件得是这个方证。

这个方证的临床症状反应：心烦是出现频率最高的，占了 118

例，不得眠只有 90 例；剩下的依次为发热、阴虚内热、尿路刺激征、口干渴、头晕目眩、下利便血。这里边有个问题就是阴虚内热，统计资料有个解释，阴虚内热包括：五心烦热、冠红（面颊红润）、盗汗、消瘦、骨蒸这一类的症状。

舌质：红舌为主，还有少量的淡舌、紫舌。

舌苔：少苔为主，还有无苔的、薄黄欠嫩的。

脉象：主要为细数的脉，其次有弦数脉、数脉、弦细脉。

有应用黄连阿胶汤机会的现代病：急性坏死性小肠炎、肠伤寒、肠出血、直肠溃疡出血、功能性子宫出血、肝硬化、肝昏迷、肺结核咯血、肾结核及不明原因的尿血及结肠血症、蛛网膜下腔出血、支气管扩张、眼球出血、室性早搏、心律失常、神经衰弱、甲状腺机能亢进、慢性咽炎、慢性溃疡性口腔炎、顽固性失音、遗精、滑精、遗精滑精的失眠症、衄血、咯血、瘀血、肺结核大咳血、崩漏、空洞型肺结核、血精、痢疾、血痢、萎缩性胃炎、阳痿、早泄、神经官能症、胎漏。

少阴病、得之一二日、口中和、其背恶寒者、①附子汤主之、（304）

注：《宋本》此处有“当灸之”三字。

附子二枚炮去皮破八片 茯苓三两 人参二两 白术四两
芍药三两

右五味、以水八升、煮取三升、去滓、一升①、日三服、

注：“一升”《宋本》作“温服一升”。

胡希恕：（音频缺如）

【释】里有寒则口中和，口中和指口中滋润，没有黄苔，不渴不

苦，胃中有饮，则背恶寒。少阴病一二日即见此候，急当温中逐饮，缓则必并于太阴而吐利也，故当灸之，并以附子汤主之。

【按】《金匱》“夫心下有留饮，其人背寒冷如掌大。”少阴病本虚，得之一二日尚未传里，但口中和，背恶寒，里寒有饮，法当温中以救里，止吐利于未萌，此良工治未病手段至于灸何穴，书中没有明文，诸家有谓膈关（第七椎下两旁三寸陷中）及关元穴（腹中线任脉脐下三寸），存以待证。

【注】

①得之一二日，且不见吐利之证，此尚未传里也。

②口中和，指口不干，不苦无黄苔等，是虚寒的标志。背恶寒，是胃有停饮，比一般恶寒重。少阴病见此证，若不早治，必传太阴为防传变，温中去饮正当其时，防患于未然也。

③本证不用麻黄附子细辛汤者，以表证不明显，亦不发热之故。白虎汤证亦可有背恶寒，但其证口舌干燥，本证则口中和，这是两者的主要区别点。

【按】本方较真武汤增加了附子的用量，以无吐，去生姜，加人参健胃补虚，防病传里。主证和组方均有别也。

本方术附合用，共走皮中以逐水气，为治湿痹的要药，根据需要可以加茯苓。若去人参，留芍药以缓挛急，可治关节痹痛。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格排版的条文。

《宋本》在“附子汤主之”之前，有“当灸之”，《康平本》里没有。

解读一下：

“少阴病，得之一二日”，在这条里，应该把它理解成是特有所指的。因为附子汤证跟少阴病不是一种类型的疾病，这儿的“少阴病”是指这个方证可由少阴病发展而来。而“得之一二日”，则是重在论述少阴病有时可在很短的时间内发展为更为严重的病症。就是因为它

比表证严重嘛，发展为更为严重的附子汤证这类的方证，与第 302 条中的麻黄附子甘草汤证的“少阴病得之二三日”，可以互参。那条论述的是少阴病虽然经过了两三天的时间，但是人体仍然保持在阴性表证的病理阶段。而这条论述的却是另一种情况，是说少阴病得了一两天的时间，就可能发展为其它类型的疾病了。我们可以这样理解，虽然这条论述的方证明显由少阴病发展而来，但是从附子汤证的病理来看，这个患者恐怕是在初得少阴病的时候，就已经有了停饮的问题了，那时候至少应该是麻黄附子细辛汤证。否则，它不可能在一两天这么短的时间内，出现了这么严重的体液代谢不良的问题，不太合乎逻辑。实际上这种病人至少存在里有停饮的倾向。

“口中和”，就是说不口渴，这是里有寒饮这类病例常见的一个证候。

“其背恶寒”，这应该是胃虚，同时又有停饮所致。

这个方剂中有白术、茯苓和人参，说明不仅有里饮，而且胃肠对水分吸收的能力也明显不足，有人参嘛。实际临床中，一般有背冷或者后背有沉重感的这类患者，多数都存在里饮的问题。白虎加人参汤证有“背微恶寒”的明文论述，但实际临床中出现的比例不高，微恶寒表现不是特别的明显，出现这类情况，它也是跟胃虚有关啦。附子汤出现这类情况，跟白虎汤证的病理似乎有点矛盾，但它又确实确实出现了这个方证，所以特意地来论述它。经方里常用这类的论述方式。

因为附子汤证和白虎加人参汤证一寒一热，截然不同，所以区分也是非常明显的。这个方子在临床中应该常用，我有一个感冒的病人，嗓子说不出话来，我就给他三天的麻黄细辛附子汤，实际上吃了一天的嗓子好了，后来把药都吃了感冒就好了。但在看病的过程中，他跟我说：我晚上经常感觉到后背冷，冬天的时候特别明显，老是得靠在一个人身上才会觉得舒服。他的工作是长期坐着，后来他出现脚浮肿，

脉又沉又有迟，口中和，背恶寒已经不像以前那么明显，但是还有。我就给他附子汤吃，吃了一段时间他感觉非常好。

做个小结：少阴病初得一二日，便出现口中和，其背恶寒的，为附子汤主治之证。

在《康平本》这条后面附有方剂。下一条第 305 条也是论述这个方剂的，所以我们就把方解和方子的运用都放在下条一块儿讨论。

少阴病、身体痛、手足寒、骨节痛、脉沉者、附子汤主之、（305）

胡希恕：（音频缺如）

【释】中气内虚则手足寒，有水气则脉沉。身体疼，关节痛，知为湿痹而无关外邪，当属太阴虚寒证，故以附子汤主之。

【注】

①身体痛、骨节疼属表证，形似外邪，虽冠以少阴病，但有无少阴病的其他脉证，故实非少阴病也。以身体骨节疼痛为主要表现者属痹症。

②手足寒，是因中气内虚、胃气不振。脉沉，为寒饮在里之应。体痛、骨节痛，为寒湿之痹。

③寒湿在里而有身痛、骨节疼痛，虽无下利、呕吐，亦当属太阴虚寒证。治之之法，不应解外而应温中逐饮，故以附子汤主之。

【按】麻黄附子细辛汤证亦有脉沉，也是内有水饮，因而（反）发热，说明表邪重，故用小汗法以解表。本方证手足寒，里虚已反映出来，故属太阴，即不得小发其汗，亦不宜四逆辈，用附子汤温中健胃去饮，以除寒湿痹痛也。

另外，风寒湿邪合而为痹，尤以关节痛为常见，并且常以表证的形式表现出来，或太阳或少阴，临证需分阴阳以治之。寒湿痹痛而

脉沉者多属本方证，尤以下肢拘急、屈伸不利者更验。

李冠杰：这是个顶格的条文。

“少阴病”，在这个条文当中，除了有跟上一条一样，本方证有可能由少阴病发展而来之外，它还包含临床表现与少阴病的症状反应比较接近，貌似“少阴病，身体痛、手足寒、骨节痛、脉沉”，所有这些描述啊，都跟阴性表证的症状反应比较接近。由于疾病类型不同，它不单单是发病机理不同，还伴有一些跟表证不同的一些症状。但是这个条文却仅仅列举了跟少阴病比较类同的这些症状，而将那些不同的症状都隐含到了方剂当中了。凡是认真读了这个条文的，都会有这样的疑问，既然附子汤证的症状反应与少阴病这么相似，但是治疗的方剂却又差别这么大，其中的区别何在啊？只要是有了这样的疑问，再来看这个方剂的药物组成，稍微一加分析，你就能够比较清楚的知道，这个方证是一种在机能沉衰的情况下，以里饮严重为主要矛盾的病理状态。所以这个方证的适应证当中，必定还会有相应的停饮证的症状反应存在。实际临床统计资料，恰恰说明了这一点。比如，这个方证的临床统计看，还有小便不利，纳呆，腹痛，便溏等跟里饮有关的这些症状。

“手足寒，脉沉”，虽然在少阴病里边也属于常见症状，但是由于这个方证的病理是阴性里虚寒，又有停饮证，所以在程度上和出现的频率上，应该跟少阴病是有区别的。特别是“脉沉”，在附子汤证当中出现的频率非常高。这本身就有机能沉衰，又有里饮，它有这样的病理存在，所以表现为这样的脉象。但是在阴性表证当中，出现“沉脉”的几率反不如附子汤这么明显。

“身体痛，骨节痛”，在少阴病里边同样也是属于常见的。附子汤证本身没有表证，“肢体疼痛”这一类的症状，是由于停饮和血虚所造成的。一方面，体液代谢不良，人体组织内的废水因为体液代谢障碍，无法正常地排出体外，而大量地滞留在体内。废水当中充满了

人体体内的代谢物，也就是人们常说的毒素，就随着这些废水滞留在体内，它不单单会刺激人体的组织，甚至使之发生病变，或者说出现症状，同时还会影响新鲜水分的输布，而造成组织失养。再加上血虚和机能沉衰的因素存在，致使患这种病的人体的肢体疼痛这类的症状，进一步地加重。这跟表证的那种把体液充斥到体表，想达到恢复体表功能的那种对神经的刺激而造成的肢体沉重有质的区别。实际上，患者的感觉也不完全一样。

下边做个小结：貌似少阴病或是由少阴病发展而来，患者表现为身体痛、手足寒、骨节痛、脉沉者，为附子汤主治之证。

附子汤证的病理是：阴性里虚寒证合并停饮证合并血虚证。

附子汤由五味药组成：附子、茯苓、人参、白术、芍药。附子振兴人体机能，在这个方剂当中，附子的用量相对地说比较大，从这儿看出机能沉衰的程度比较严重。茯苓、白术去饮，白术的用量也比较大，这味药在治疗寒性水饮的同时，还有治疗因为这种寒性水饮所造成的痹证的作用。治寒又有水饮的药很多，能够同时去水又能治疗痹痛的药，白术就是一个比较典型的一味药，它的这种功能比较明显。芍药用来治疗因为血虚而造成的组织肌肉的一些疼痛。

下边是方证。这个方子统计得比较细致，这也反映出它的症状比较繁杂，而且症状出现的频率，频率高的和频率低的差别，不像我们前面讨论的那些方剂那么明显。说明凡是由水饮造成的病，临床反应就呈现多样性，就是所谓的怪病。常常辨证不是那么的集中，那么明确，那种所谓的抓主证的理念，你要是用在这个方剂里边，就不好用了。

症状一共统计到了 106 例。在这些症状里边，表现最多的是畏寒肢冷，有 45 例；面色苍白有 40 例；纳呆的 38 例；像神疲、心悸、腹痛、便溏、腰膝酸软、全身关节痛，这都是在 20 次以上的；像浮肿、眩晕、失眠、自汗、呕吐、口淡乏味、月经不调、小便不利、小

便清长、喘促、倦怠乏力，这些都是 10 次以上，20 次以下； 10 次以下的，口渴、不欲饮、心下痞硬、带下如涕、面青，这些最低的，出现频率最低的，也在 8 次以上。

这些症状频率最高的和最低的，也不是差很高，最高的也只有 45 次，最低的还 8 次。再加上这么多的症状反应，所以这种方证何来主证？你要抓主证，怎么抓？辨病理在这类方证上，就显得非常重要。

舌质：淡舌、紫暗舌、红舌兼有瘀点的舌象。

舌苔：有白苔、黄苔、灰苔。

脉象：沉脉，出现的频率比较高，79 例有脉象纪录的医案有 50 例见沉脉。往下就是细脉、迟脉、弦脉，另外还有少量的像虚脉、弱脉、紧脉、微脉、伏脉。这是附子汤的方证。

有应用附子汤机会的现代病也挺繁多：风湿性心脏病、冠心病、心绞痛、心肌梗死、心功能不全、高血压病、血栓闭塞性脉管炎、动脉血栓、动脉栓塞、雷诺氏病、慢性肾炎、肾病综合症、肾功能衰竭、肝炎、慢性支气管炎、肺气肿、慢性细菌性痢疾、慢性结肠炎、子宫内膜炎、子宫脱垂、子宫糜烂、附件炎、盆腔炎、阴痒、产后汗出、妊娠恶阻、妊娠小腹寒冷隐痛、妊娠中毒症、白带过多、月经后期、子肿胎胀、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、阳痿、滑精、尿闭、多尿、遗尿、皮肤瘙痒、盗汗、鼻衄、吐血、暴暗、呕吐、癫痫、腹痛、腰痛、浮肿、神经痛、肌肉痛、胃下垂、慢性肠炎、脱肛、内耳眩晕症。这些病中有一些不是规范的西医病名。但是我们本着实用的原则，只要能帮助我们理解这个方证就可以了。

少阴病、下利、便脓血者、桃花汤主之、（306）

赤石脂一斤一半全用一半筛末 干姜一两 粳米一升

右三味、以水七升、煮米令熟、去滓、内赤石脂末方寸匕、温服七合·日三服、（注）若一服愈·余勿服·

胡希恕：（音频缺如）

【释】少阴病转属太阴，下利便脓血久不止者，宜温中止利，桃花汤主之。

【按】下利便脓血，即今之痢疾的黏液脓血便。若脉微沉细而无里急后重，滑泄不止者，可与本方止之。若脉滑数而里急后重，多属实热，非温涩所宜，不可轻试本方。

【注】

①此当有少阴病的脉微细、但欲寐，而又下利、便脓血，是少阴病传里而转属太阴的虚寒下利。便脓血是下利日久，寒湿浸淫大肠，以至滑脱经久不愈，故下利不止。无热象，应不渴而口中和。

②这种下利宜温中固脱，故以本方主之。阳性病之下利，因正气不衰或里实，故一般有里急后重，万不可上来即用止泻药，使毒素潜伏于体内留下后患。

【按】临床用本方的机会很少。本条为证不全，应与下条互参。

李冠杰：这个条文是顶格的条文。

解读一下：

“少阴病”，是指桃花汤证常伴有与少阴病症状反应比较类似的一些证候，比如“脉微细，但欲寐”；也不排除桃花汤证初发病的时候，可能是由少阴病发展而来的这类的状况。但是在实际临床数据当中，这类情况不多。

“下利，便脓血”，跟白头翁汤证的症状反应颇为近似。但是结合治疗方剂来分析，桃花汤证是一种虚寒证的下利。在寒热属性上，跟白头翁汤类方，正相反。这个条文论述的，发病就是虚寒性而且以下利便脓血为主要症状反应的情况，实际上就是急性菌痢。急性菌痢指的就是以下利便脓血为主要的症状反应。

但是，桃花汤这个方剂，在临床当中多用来治疗慢性的腹泻。实际上，只要是符合虚寒性的下利便脓血这种基本特征，不管病程长短，都可以使用这个方剂来治疗。

做个小结：有少阴病的某些症状反应，同时表现为下利便脓血的，为桃花汤主治之证。

这条后边附着方剂，下一条也是论述这个方剂的，我们就放到下一条一块儿讨论。

少阴病、二三日至四五日、腹痛、小便不利、下利不止、便脓血者、桃花汤主之、（307）

胡希恕：（音频缺如）

【释】少阴病，二三日至四五日常传里转属太阴，其腹痛、下利不止、小便不利、便脓血者，桃花汤主之。

【按】此承上条而详申其证也。以上两条均指脉微细、但欲寐的少阴病并于太阴，便脓血下利不止，即所谓阴证下利，故以温中固脱的桃花汤治之。

【注】

①少阴转属太阴，里有寒则腹痛。里虚寒，水谷不别，水不走前阴而入肠道，故小便不利而下利不止。若下利不止，津水伤，亦可使小便不利。二者互为因果，均可造成虚脱。

②虚寒阴证的下利急需固脱止利，故仍以桃花汤主之。

李冠杰：这个条文也是一个顶格排版的条文。

在这一个条文当中又用了“少阴病”，这个“少阴病”意思呀实际上跟上一条是一样的。

接下来“二三日至四五日”，正是这个条文论述的一个重点所在。这里论述了一个什么呀？论述了一个在经方里边非常少见的、很宽泛

的，你看要如果说按我们今天这样理解啊，二三日至四五日，这都接着呢，这一共是多少？就是四天的时间。但是，实际上他这里论述是特意的，就是说病程比较长。那么，言外之意还有另一层意思，一个是病程比较长，这是其一，另外一个呢，就已经治疗了而不得愈的这种情况。而且这个方证啊，它有这个特点，就是说你用其他的方剂治，而且很容易用其他的方剂治。你比如说，理中汤，用理中汤的机会，也就是说一开始看就想到用理中汤，这里边特别是不便脓血的时候，只是下利，就会。但用了以后它不管用。

“腹痛”，这个“腹痛”呢，一方面是由于久有里寒；另一方面呢，得是由于这个病程比较长，使消化道内病变像咱们常说的这个发炎哪，或者说肠黏膜脱落这一类的。那么实际临床当中这个方证当中的“腹痛”，多呈现为少腹冷痛，就是小肚子这个地方又冷又痛。你像现代医学认为这一类的疾病啊，它常伴有胃肠黏膜的病变，或者是消化道出血。这一点呢，这个认识没有错，这是个事实。可是，如果放到经方医学里边衡量的话，你会发现，这种症状和这种疾病，如果说跟白头翁证比较的话，放到现代医学里边，这病变是一样的，你比如说一个病人都有阿米巴氏痢疾，桃花汤证里边有，白头翁汤证里边也有。那么在现代医学里边是一种病，但是在经方里边，甚至在中医里边辨的话，它就有寒热之分，那么，实际上真的分的什么呀？分的对象不同。

接下来“小便不利”，这个“小便不利”主要是由于持续的长时间的下利，造成人体的津液虚损，当然也不排除因为人体长期下利以后，机能偏于低下而造成体液代谢不良的疾病这种可能。但是，有下利而且持续时间比较长的因素存在，这是肯定的啊，造成小便不利，小便减少，这个是肯定的因素。像那个有没有停饮，要用其他的症状来佐证才可以。

“下利不止，便脓血”，这儿“下利不止”，看啊，跟那个第

306 条当中的“下利”，一比较你就会发现，这儿说得明显严重得多，这其中不仅含有长期下利，而且含有久治不得愈的那种，“下利不止”嘛，止不住。所以这个条文论述的是一种慢性下利啊，这就跟 306 条就有区别了。那么“便脓血”呢，是这个方证的一个典型的症状反应。但是这个“便脓血”，跟白头翁汤证的“便脓血”不同，这个方证当中的“便脓血”，因为是一种寒性的下利，临床当中呢，这表现也不一样，虽然都是“便脓血”，像这一类的在排便的过程当中就没有那种灼热感，而且所排的大便味道也不浓。但是，刚才我们也说了，像这些区别在现代医学好像都不重要，它治的是什么呢？它治的是你什么样的菌给你造成的，这些菌对胃肠道黏膜发生了什么样的危害，它要去杀那个菌。至于说人体偏寒偏热，他们也没有这方面的意识。那么这里边会带来什么差异呢？你比如说啊，像白头翁汤那一类的痢疾，你要是输液用抗生素治疗的话，用西医的输液办法治疗，比较容易治愈。但是桃花汤证，如果说用输液的办法来治疗，恐怕疗效要差。为什么？因为它毕竟是一个寒证，而我们所输的液体呀，放到我们中医来说都是一些寒药，寒性药，所以说常常疗效不好。

去年德国出的那个就是说下利的病，那个病实际上就是一种寒性的，因为它后来就说没药治，输液是不管用的。为什么呀？你观察得细致一点啊，就是说凡是寒性的病，就是中医认为偏寒的病，用输液的方法治疗效果都不是特别好。

另外，在这个方证的临床统计资料当中还有一个值得注意的现象：就是说这个方证在发病的季节上，它主要分布在春季、夏季和秋季三个季节，所有统计到的医案，冬季一例也没有。但是，白头翁汤证就是四季都有。那么，这两个方证又同时都是夏季发病较高。

这个统计数据很耐人寻味，大家想想这里边说明什么问题啊？我在这儿给大家提示一下，大家自己去想：咱们在学白虎加人参汤证的时候，大概是王叔和加了那么一段注解，就是说那个方剂天冷了不能

用，就是冬季前后不能用，立秋以后就不能用了，非得是天热的时候才能用。为什么啊？因为那是一个寒药。实际上那种解释根本就不对，只要是那个方证，不管冬天什么的，你就可以用。那么，他怎么出来的那种理念呢？临床当中说明他有辨证不对的，他肯定有临床基础，那么他有辨证不对的；或者说他第一次在冬秋季用那个药的时候病人出现腹泻了，后来发现这个药是寒性药，冬季不能用，实际上这里边有错误，他自己误导了自己。什么把他误导了？他那一套错误的理论把他误导了。因为原理上冬秋季人不得热证，或者说常得寒性病，大家慢慢去想吧。传统中医里边，就是说有一些是从临床当中来的，有的总结不是很全面，有的就是一些故弄玄虚，弄的天花乱坠的。但是实际临床当中，也跟实际的临床数据对不起来。你像这桃花汤证，明显的就是一个虚寒证。但是冬季却一个没有。当然它肯定能说明什么问题啊？冬季发病率比较低，这是肯定的；另外就是说桃花汤证和白头翁汤证夏季发病率都比较高，为什么啊？夏季人吃东西，病从口入的机会比较多。这说明什么？说明凡疾病都有两个因素，都有两方面的因素，外界因素确实是个致病因素；但是人体内里的因素，也是一方面的因素。两个方面的因素都得看到，这才还原事物的本来面目。

就像现在搞的 H7N9 这个病，前两天电视上又报道说，说哪一类的人是高危人群，哎哟！我特想听听他怎么解释，结果他解释了一个非常简单的问题，说高危人群就是那些接触家禽机会比较多的人。还是他那个理念，就是一门心思地去找外因。因为他没有能力去研究内因，所以说也没有这种理念。你找外因，结果到现在还没有找到，就是人和人之间不传播，好多没有接触过家禽的也在得病，最终还是一个无头案。实际上你要放在中医里边，我们现在还没见到这种病人，可是在一边看，我们心里边是清清楚楚的。换一句话说，如果坐到我们身边一个病人的话，其实也没有什么特殊的，咱就是四诊，你在四

诊过程中辨他的寒热虚实就是了，辨这些病理，然后辨方证不就完了嘛。

下边做个小结：

患少阴病二三天，或至四五天以上，患者表现为腹痛、小便不利、下利不止、便脓血的，为桃花汤主治之证。

那么下边呢看看方剂：

桃花汤有三味药组成：赤石脂、干姜、粳米。方剂当中的赤石脂是一味温性药，有涩肠、止血、敛湿、生肌的这种作用。但是这个药的温性，好多药典上说是性平，但是从它治的病来看，这是一个典型的虚寒证，方剂当中仅仅干姜这一点点量，肯定不足以治疗这样的虚寒证。也有的资料上说它是个温性药，我就持这个观点，它应该是一个温性药。那么，这是一种矿物质，是多水高岭土当中的一种红色的，就跟粘土差不多的一种东西。这个干姜在方剂当中的作用就非常简单了，就是安中温里补虚。粳米在这个方剂当中的作用有点像白虎汤当中的那个粳米，跟那个作用比较相似，特别像这个方剂当中的赤石脂这味药，它有使其吸附在胃肠粘膜上。但是还不完全，它对那些病变，胃肠粘膜发生的那些病变，它既有保护作用，也有治疗作用，应该这么理解。那么这个粳米当中的黏性肯定可以辅助，因为它本身就能保护胃黏膜嘛。它跟赤石脂合在一块，你可以想象到，这好像就是什么啊？就像那个你刷涂料的时候，像咱们刷涂料，涂料里边的颜色实际上是涂料里边的添加物，那么我们可以把粳米的黏性想像是涂料，赤石脂等那些药物就相当于添加物，添加在里边。它粘附在胃肠粘膜上，既起到保护作用，又起到治疗作用。

但是这个方剂的方后注解，大家可以看一看，很可能这原文有残缺，因为这个方剂好像平时我们用的机会都不很多，可能大家一般地不去细推敲它，你要仔细去推敲它，这里边有矛盾的地方，而且在经方里边这种矛盾非常少见。这个方药的注解里边要求把这个赤石脂，

用一斤的赤石脂，然后用一半。所谓全用，后世解释就是用布把它包起来，然后把它放到锅里边，就是煎药的时候煎；那么另一半筛末。它这是一斤，一斤是 250 克左右，这样实际上就有 125 克左右的赤石脂筛末待用。但是这个方后注解当中，只是要求在煎好了这个药之后，往里边加赤石脂末，加一方寸匕，那么这一方寸匕有多少啊？大概有 3 克左右，就这么一点。要如果说按照这种方法的话，这样就完全没必要把半斤的赤石脂筛成末待用，就完全没必要了。因为你把它筛出来，只用 3 克，其他的那些怎么办啊？在经方里边还没有这种情况。所以说，或者说药物注解里边有错，或者说是方后注解里边，有不完整的地方，或者说出错。

通过《康平本》里“温服七合”这个旁注内容，能明显看出来这个地方的原文或是有残缺，或是它没有给交代服多少量，所以后人才在此处补上了“温服七合”的旁注。这个煮就是煎药。可以理解成它用七升的水，但是到米熟了就行了，不管剩多少水都没关系。

正因为这样，临床应用当中就五花八门了，什么样的都有。有的人就按照原文的这种方式，真的是一部分煎了，另一部分研末喝一点，人直接喝进去，还有这样的；也有的就直接不管这一套了，就直接把所有的，他理解的那个“一斤”，当然量没有这么多了，就把所有的赤石脂呢，都入汤剂熬着用。但是呢，从临床疗效来看呢，没有实质性的区别。把这赤石脂服这个末的和不服这个末的没有太大区别。但是从理论上说呢，因为这个赤石脂呢，他用的是这一类的属性。所以说有时候喝一些这个散剂啊，喝进去呢，可能疗效理论上会好一些。所以说，有这一类的要求。

但这个地方呢，原文确确实实是应该有矛盾的。

下面呢看看桃花汤的方剂的症状：有下利、腹痛、神疲乏力、纳呆食少、背寒肢冷、面色无华、体形消瘦、里急后重、小便不利、恶心呕吐啊，有这一类的症状。

舌质：以淡舌为主，其次有红舌，但是很少，还有暗红舌，红绛舌，这个比例都比较少。

舌苔呢：是以白苔为主，还有少量的黄苔黑苔。

脉象呢：以沉脉为主，另外呢细脉、微脉、弱脉、滑脉、数脉，那么滑脉、数脉非常少。

从这个现代应用来看呢，主要的有下面一些疾病：急慢性菌痢、阿米巴痢疾、慢性结肠炎、肠伤寒、消化道出血、胃肠神经官能症、胃及十二指肠溃疡出血、胃功能紊乱、小儿疳泻、子宫功能性出血、白带过多、崩漏、带下、尿路感染、脱肛、痔疮。

少阴病、下利、便脓血者、可刺、（308）

胡希恕：（音频缺如）

【释】少阴病，下利便脓血者，除以温中固脱的桃花汤主之外，亦可用针刺辅助治疗。刺何穴，如何刺，书中无明文。

【按】可刺，乃可用针灸之法作辅助治疗。愚以为用灸法辅助之更妥。不管针灸还是汤药治疗，此等下利万不可用苦寒之法。

李冠杰：这是降一字格排版的条文。

下面我们解读一下：

这个条文的论述非常简略，从述症上看，跟第 306 条的桃花证是一样的，可以理解为桃花汤证类方证，近似的这类的症状反应，也有应用针刺治愈的机会。既然这是一本方书，他在这个地方特意提到了可以用针刺的方法来治疗，这就暗含着有什么？他有某种不宜用汤药来治的因素在里面。我们在这假设一种因素，你看桃花汤证对的是一种里虚寒的证，很多有临床经验的经方大师，都有这方面的说法，如果不是里虚寒证的话，千万不要轻易地使用这个方子，也就是说它的应用指征非常明确。

我们再看白头翁汤这一类的方证，都是些苦寒的药，那得是很热的证。既然里虚寒证也有可能出现，比如刚才说的那个阿米巴痢疾，虚寒证有可能出现，里热证也有可能出现这个病；那么不寒不热的人会不会也出现这种疾病呢？他寒热倾向不明显，但是得了阿米巴痢疾，像这一类的，恐怕用中药疗效会打折扣，因为寒热这个属性就对它不太适应。这个时候也许用针刺的办法，可能效果会更好一些。特别是针刺的办法也没什么副作用。

虽然条文论述了“少阴病，下利，便脓血，”可以用针刺的方法治疗，但是没有给出具体的穴位，从后世医家的临床实践中，确实有用针刺来治疗这一类疾病的技术。也就是说真的有人能用针刺的办法控制便脓血这一类的疾病。这一类的条文我们可以做参考。既然这个作者写到这儿，恐怕是临床当中，或他本人，或者别人有将这一类的方证治愈的这种技术。

少阴病、吐利、手足逆冷、烦躁欲死者、吴茱萸汤主之、

（309）

吴茱萸一升 人参二两^① 生姜六两切 大枣十二枚擘

右四味、以水七升、煮取二升、去滓、温服七合、日三服、

注：《宋本》本方有三，人参一味一方作“二两”，二方作“三两”。

胡希恕：（音频 034 始）……这个吴茱萸汤证以吐为主啊，吐的厉害，啊。这个，这个吴茱萸汤，啊，这个证候我可遇着多了，真是这个样子，那个人真要死，啊，她自己也是，以前我一个邻居呀。她就是一犯这个病，那一点也起不来，就是吐，啊，同时头晕。就是我先…先前讲那一个，啊，啊…水饮上冲的那个晕。啊，头眩晕的厉害。他可不…不时时自冒，啊，跟这个病是一样的，手足逆冷。她一

吃这药就好，啊。我就给他吃这个吴茱萸汤，她自己都记住了，她一犯病啊，就找我“我还吃那个辣药”，这一个方子呀，又苦又辣，啊，辣的很。所以这一个啊，虽然说是吐利，利并不厉害，以吐为主的，啊。当然他里头这个水多呀，他既吐，他下边也利，不是一点也不利，啊。同时手足厥冷。这个气冲得厉害，手足厥冷也不…不一定是这个胃气全败了，你得看情形，是吧？那么假设胃气败那种手足厥冷，那就是头前儿那个就是的，只躁，啊，躁烦，啊，不得安宁，那个死证是那样子。那么这一个手足厥冷呢，他这个气往上啊，这个水气冲逆得太厉害了，这个胸中这个大气受阻碍，他手足也逆冷。这一个，因为这吴茱萸汤我常用，啊。不但治这一类的病，你像我们在临床上一一般的这个，西医说这个美尼尔氏证那种头晕呐，这个方剂很多呀。他只要是晕得厉害又吐，那准是吴茱萸汤证。这个在…啊，就在门诊上我也没…没断用。这一个方子非常好使，这个方子他是个温中、健胃、祛水。这个吴茱萸汤就专制水气上冲。可这个药呢，是大温呐，大热。真正的…真正有热可不行。你像咱们那个柴胡剂那一个，那个呕，那不行，那吃上就坏。他阳明篇不有嘛，是吧？食谷欲呕者，属阳明也，吴茱萸汤主之，得汤反剧者，啊，那就是属上焦也。那就指的柴胡证。所以要真正的有热吃这个药，是越吃呕越厉害，啊。在…在这个头前儿太阳篇里头有。那么这一段呢，他在少阴篇里也搁上了。因为少阴篇呐，他经常的呕吐下利，这是一个危险的证候，在这个并发太阴病。但是也有似是而非的。那么这一个就是，啊。这一个当然也是中虚有饮呐，这肯定的了，啊。那么这一个他不是死证，他是烦躁欲死。像，啊，要死的…要死之证，就是他是冲那一节儿说的。这一个，这种病很多。这一个病到不要紧的。哎，咱们今天就讲到这了。这个少阴，少阴篇呐，你们好好看一看。他这一个，这一篇最不好懂，啊，啊…他这个文字是也有关系。你看这两个，这两段，啊，他就一个“烦躁”与这个“躁烦”，他都搁到这一个地方了，这就是容易误解的。那么

那个吐逆，手足逆冷，啊，烦…啊，躁烦者死。为什么这一个还要治呢？不但治，这个病与那个病是截然不同。这个是…不是个重病，啊。这一个不是，他说热烦躁欲死啊，只是他这个呕吐，这个折腾那个，那个样子，啊。

李冠杰：这个条文在《康平本》是顶格排版的条文。

解读一下：

这个条文论述的，实际上是吴茱萸汤证的一个重证。吴茱萸汤证在第243条已经有过论述，就是“食谷欲吐”这么一个症。我们可以理解成是以“呕吐”为症状反应的吴茱萸汤证的一个轻的症状。关于吴茱萸汤证的论述，顶格条文就只有这么两条。

“少阴病”，在这个条文里边应该理解为：近于少阴病提纲里边的脉微细，而胃肠功能严重低下的里虚寒证。那么，吴茱萸汤证这个胃肠功能低下到什么程度呢？胃部对水分的吸收能力也都变得非常得微弱，从而造成胃中停饮。轻的会恶心呕吐，重的还会引起腹泻。就说该吸收的水分没有吸收，称之为“水走肠间”了。

“手足逆冷”，常常是胃气衰败的一个证候。实际在临床当中，吴茱萸汤证的重症患者，不仅仅是恶心、呕吐、头晕、头痛，严重的时候一点东西也吃不下去，根本就不能进食。也等于人体来自消化道的能量几乎等于零，能量的来源就没有了。在这种情况下，出现“手足逆冷”之类的症状反应，这是一种很自然的事儿。

“烦躁欲死”，是因为患者感觉身体严重不适，给精神上造成一种极度的痛苦，就是非常痛苦这样的症状反应。都是人体内环境严重失衡的结果。但是不同的方证，其病理基础不一样，临床反应也是不同的。阳明里实热证的“烦躁”，是人体机能偏于亢奋造成的，常常表现为“谵语”，甚至“其人如狂”；少阳病的“烦躁”，以栀子豉汤证为例，是在半表半里虚热证的病理状态下发生的，以患者不得眠，坐卧不安这一类的症状为症状反应；烦躁也属于太阴病的范畴，但是

情况稍微特殊一点，胃肠功能因为里虚寒证重，处于一种近乎停滞的状态，这就造成了一种供需矛盾。一方面人体需要能量，另一方面能量来源又不足。出现了人体内环境的失衡，就不平衡了。

这个病呢，我得过两次，真是挺难受。就说你躺着不是，坐着不是。坐在饭桌前，一点东西都不想吃。还有一次就是晕得厉害，一动就要吐。

吴茱萸汤证就其病理而言，属于太阴病。

在经方理论当中，论述它的条文一共有五条。《伤寒论》里边三条，《金匱要略》里边还有两条，其中一条跟《伤寒论》第 378 条重复了，内容是一样的。我们这样，要是整体地把所有的关于吴茱萸汤证的这些条文都联系起来，整体地来解读，我们对吴茱萸汤证，就会有一个比较全面地认识。吴茱萸汤证最常见的症状是什么呀？是恶心、呕吐、头晕、头痛，这是最常见的。

有这么一个病人，春节以前来我这儿看病的，来的时候是个什么情况呢？她一直在住院，心脏病，人弱得不得了，年龄不大，50 多岁，饺子她自己都包不了。我就根据她的情况开了药，她吃了大概一个多月的药，明显得轻了。轻了以后她就一直在吃药。前天又来了，这次呢，她说：我老是头疼，虽然不是特别厉害，还是有一些疼。我根据经验确定用吴茱萸汤，线索在哪儿呢？她始终是脉迟。而且我给她的方剂里边就包含了吴茱萸汤。她浑身到处是病，大概得五六个方子合到一块儿的。我就问她：你会不会有时候觉得有些恶心啊？她说：有时候有。她脉迟得厉害每分钟只跳了 58 次。我就给了她两天的吴茱萸汤。两天以后她回来了，她说头疼好了，恶心也没了。结果又接着吃前头的药。

做个小结：形似少阴病，患者表现为吐利、手足逆冷、烦躁欲死的，为吴茱萸汤主治之证。

少阴病、下利咽痛、胸满心烦者^①、猪肤汤主之、（310）

注：《宋本》无“者”字。

猪肤一斤

右一味、以水一斗、煮取五升、去滓、加白蜜一斤^①、
白粉五合、熬香、和令相得、温分六服、

注：“加白蜜一斤”《宋本》作“加白蜜一升”。

胡希恕：那么虽然他也冒一个啊，“少阴病”啊，那么这个是…他是少阴病是…传入半表半里发为少阳病了这是。“胸满、心烦、咽痛”这都是热上炎的一种证候了。那么可见这个下利也是热利，不是寒利了，不是虚寒的下利了。他用猪肤汤主之。猪肤这就是这个，这个药就是用这个，啊，猪皮一味。这个猪肤这个药啊，“润燥解热”，啊。它是祛热的不是祛寒的。它另加白蜜，啊。是这个甜药都能够缓痛，啊。加白蜜就治嗓子疼。那么另加白粉，这个白粉就是米粉，啊，这是，啊，以治利，啊，这是安中养胃的法子。这个病很轻，啊，这一个他主要的他是要下，往下讲这个咽痛了。那么这个病就是这个少阴病啊，它是啊，以传厥阴太阴为常，但是也有兼传阳明…阳明少阳的，啊。那么这一段呢，它就是传，传入少阳。它也是表证嘛。所以这个表证传里…那么它可以为阳性证，也可以为阴性证了。那么太阳病呢，传里它…以阳明、少阳为常，但是也兼有传入太阴和厥阴的，啊，一样，这个阴阳两种病啊，它阴病以传阴为常，啊，因为他虚，他根本就虚，所以它传入里也传太阴、厥阴为常。也少…也有，啊，传少阳、阳明的。这个书上也是这样子。那么这就是其间一个例子了。

李冠杰：这个条文在《康平本》是顶格排版的条文。

条文里边“胸满心烦者”，在《宋本》没有“者”字。

解读一下：

“少阴病”，应该理解为有某些与少阴病类似的症状反应，或者

由少阴病发展而来。

“下利”，在猪肤汤证应该是一种虚热性的下利。但是在临床统计资料来看，这个方证出现下利的几率非常低，没有一例出现下利的症状。

“咽痛”，是猪肤汤证的一个典型症状。

有应用猪肤汤机会的现代病，慢性扁桃体炎、咽喉炎、失音、口腔溃疡、牙龈出血、口腔和咽后部位的一些病变。由此可见，这儿的“咽痛”，实际上按现在的说法，就是咽喉部位的一种炎症。在这个方证当中，咽喉部位这个炎症比口腔其他的部位出现的频率明显偏高。不仅仅是咽喉这一个地方，而是整个口腔部位出现的一些炎症，但是以咽痛出现的频率比较高。

这只是从疾病的角度来分析，如果从发病病理的角度来看，这个方证属于阳性的半表半里的虚热证合并血虚证。

所以，只有在这个病理的基础上，而且在具体地表现为猪肤汤证的症状反应，才是这个方剂的适应证。这也正是经方医学的精髓所在。这个方证的“咽痛”，要是用其他的方剂，比如甘草汤、桔梗汤治不了。同样的，其他方证所能治疗的“咽痛”，这个方剂也治不了。

这个“胸满”，在这个方证出现的几率也很低。在 17 个医案当中也都没有出现“胸满”这个症状的记录。但是从这个方剂对应的现代疾病来看，其中包括了肺结核、慢性支气管炎这一类的疾病。临床当中有“胸满”这一类的症状是完全有可能的。

“心烦”是半表半里证常见的症状反应。半表半里的虚热证，常常对人体的精神方面有所影响，特别是像柴胡加龙骨牡蛎汤。本方剂在临床应用当中，常被认为是治疗咽痛的一个专用的方子。凡是遇到咽痛时，就给他吃，看中的是这个方剂里边药物的平和。但是，并不是所有的咽痛用这个方子都能治。

有些专家说经方里有专病专方，甚至解释得非常得生动，但是这

个最终都会误导人。因为经方不是那样治病的，经方对的是方剂的适应证，而不是具体的疾病，凡是确确实实表现为这个方剂的适应证的，它是什么病都没关系，都可以治好的。

那么猪肤汤的病理：是半表半里的虚热证合并里虚热及血虚证。

作个小结：貌似少阴病，患者表现为下利、咽痛、胸满、心烦的，为猪肤汤主治之证。

还有白蜜、白粉。这个方剂的三味药，实际都是日常当中常用的食品。猪肤就是猪皮，是寒性的，可润燥解热。从治疗的症状和疾病，这味药应该还有补血止血的作用，这个药物与阿胶有相似之处；米粉，也略微偏寒，有补中止利的作用，对下利有益处。白粉，从治疗的症状和疾病来看，应该是米粉。

这个方证的症状：频率最高的是咽痛，其次是声哑、干咳少痰、口燥咽干、心烦、食少、纳呆、体型消瘦、咽痒、发热、喉肿、遗精。

舌质：全是红舌，虚热比较重。

舌苔：白干苔、粉白苔。

脉象：细脉、数脉，明显是虚热证。

有应用这个方剂的现代疾病：胃炎、麻疹、白喉、痔漏、遗精、原发性血小板减少性紫癜、营养不良性贫血（有补血的作用）、再生障碍性贫血、血白细胞减少症、肺结核、糖尿病、尿崩症。

少阴病、二三日、咽痛者、可与甘草汤、不差、与桔梗汤、（311）

甘草汤方

甘草二两

右一味、以水三升、煮取一升半、去滓、温服七合、日

三服①、

注：“日三服”《宋本》作“日二服”。

桔梗汤方

桔梗一两 甘草二两

右二味、以水三升、煮取一升、去滓、温分再服、

胡希恕：那么这一个也是，这个少阴病这个咽痛啊，这古…大概古人把它搁到少阴篇里他有用意的。这个…旁的咱没看着这个，啊，扁桃腺发炎咱们经常在临床上遇着啊。像这一种病来呀，都带着感冒，啊，也是开始发烧怕冷。那么这个咽痛呢？啊，轻的没关系，重的咽痛啊，不能发汗。忌发汗，啊，所以“发汗封喉”嘛，啊，啊…总是要用一种这个清凉解热的法子。所以他搁到少阴篇里有用意的，他搁到太阳篇里头，啊，容易当太阳来发汗。这个少阴病，啊，是发汗的机会不太多的。所以他搁到少阴篇里头。按理说应搁少阳篇里头。这个“口苦、咽干、目眩”呐，“眼睛红、耳朵聋”，都属于少阳，是孔窍的病都应该属于少阳。那么这一个书呢？它搁到少阴篇里头。是不是这个原书就这样子，啊，或者是这个王叔和他把它挪到这儿，咱们都不知道了。但是咱们要知道，啊。那么就是有少阴病的外观，也是由少阴病内传少阳而发生咽痛，可以这么理解。那么一般这个咽痛啊，它都指着这一个一侧，啊，局部痛，说咽痛。那么后边他就说“咽中痛”，整个嗓子都痛，那是重了。这个局部咽痛呢？就是咱们平时所说这种这个，啊，一侧红肿啊，就是咱们说扁…扁桃腺发炎这一类的病。轻的话，就是用甘草汤就行，就是甘草一味。甘草这一个…要是生甘草，啊，它也解热，解毒，啊，止痛。要是重一点的，啊，要是红肿轻，吃甘草汤就可以好的；要是肿的厉害一点，吃甘草汤不行再加桔梗。桔梗这个药啊，它有利于咽痛，啊。后世说它开脾，又是提气，不对的。它这个药就是一个排痰、排脓。那么嗓子这块儿又疼，

又觉着这块儿不利落，可以加桔梗。那么一般的这一个，啊，这是轻症，啊，要是重症啊，啊，只是用桔梗汤也是…也是不行的。桔梗就是甘草加桔梗。啊，咱们一般治这个扁桃腺发炎呐，在临床临床上啊，常用这一个，我常用这一个小柴胡汤加石膏，加桔梗，它那里就有甘草了，啊，很好使。但是特殊重的，要如果这个扁桃腺化脓了，就不行了。就是小柴胡加石膏合用桔梗汤，也不行了。那就得想法子用这个增液汤这一类的，就是白虎增液，啊，或者用玉女煎这一类的方子，啊，加上这个，啊…马勃呀，或者其它的这一个，啊，啊…祛痰治嗓子疼都可以的。这是我们经常见的病，啊，这是都说的这个。他凡是说咽痛啊，都是局部，很轻，所以用甘草桔梗汤都行的。甘草汤要是不好呢，就用甘草桔梗汤。这个甘草汤呢，用一味二两，用水三升，煮取一升半，去滓，温服七合。就是匀两次服了。这个二两呢，拿着这一个以前这个度量衡说是六钱，六钱它分成两次，就是一次还是三钱。我们平时用量就是三四钱，那么现在咱们以克计算了，就是 10 克、12 克这样就行。桔梗汤呢？就是甘草又加桔梗。这一个量更较比轻了，甘草还是那么重，它桔梗轻，啊，桔梗搁甘草的一半。也就是甘草搁三钱，桔梗呢？就是这一个，啊，一钱、一钱半。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格排版的条文。

解读一下：

“咽痛”，这儿单纯指的咽喉部位疼痛的症状，是条文里唯一的述症。实际临床中，这条论述的两个方证常常跟其它类型的疾病同时出现，比如太阴病、太阳病、或者少阳、少阴病。只要有其它类型的疾病存在，就再也没有单独用这两个方剂的机会了，而是应该与其它的方剂来合方。明白了这一点，条文里论述的“咽痛”就比较容易把握了，实际上这个“咽痛”应该是在没有任何其它类型疾病的情况下，出现了一种以“咽痛”为主要证候、症状反应的一种疾病。

条文里论述的“可与甘草汤，不差，与桔梗汤”。应该实事求是

的结合临床实际来客观地加以分析和理解。甘草汤它适用于单纯性的轻症咽痛，或者是这个疾病的初起。所以在临床中应用的机会不多。虽然这个方剂在现代应用中有咽炎、扁桃体炎这类的疾病，但从统计的临床医案来看，没有一例是用来治疗咽痛的，就可见在临床中单独出现甘草汤证的机会不多。相比之下桔梗汤在临床来治疗“咽痛”的机会明显多于甘草汤。

昨天我妻子感冒了，感觉身上发冷，还有点一阵阵发冷，嗓子痛得厉害，鼻塞、流鼻涕，我就给她柴胡桂枝汤 6 克，合上 4 克桔梗汤（都是现在的粉剂），让她分三次喝。从昨天下午一直到晚上睡觉喝了两次，咽痛就好了。就剩下还有点鼻塞、咽干、想喝水。我今天又换成小柴胡汤加一点石膏。她还有点鼻塞，本来是想用小柴胡汤合上越婢汤，但是手头上越婢汤没有了，就加一点石膏吧，因为症状已经很轻微了。

桔梗汤在临床中治疗咽痛的机会是比较多的。学习这条能发现这两个方子用药都非常简，除了用来治疗咽痛之外，像这些小方子还可以用来治疗其它的疾病，像桔梗汤在《金匱要略》“肺痿肺癰咳嗽上气病”篇里用来治疗肺癰，治这类病都有用桔梗汤的机会。

最后再重新审视下条文可以这样理解：少阴病经过二三天的时间出现咽痛的，可以用这个条文论述的方法来治疗；如果少阴病仍然存在的，可用相应的方剂合并上这两个方子来治疗。实际这样就等于面宽了，其它的疾病说的是少阴病，如果有少阳病也没关系。

甘草汤证的病理：半表半里的虚热证合并里虚证。

桔梗汤证的病理：半表半里的虚热证合并血瘀证。桔梗汤有排脓的作用。

有这么个例子，一个患者吃了大量的有毒野草（大概类似于蘑菇这类的），出现腹痛、恶心、头晕、出冷汗、全身无力、呕吐这些症状，后来就给患者服大量的甘草汤，用一千多克甘草熬汤喝，二个

时以后症状开始缓解，六个小时以后诸证消失，就痊愈了。这类的疗效，现代医学用输液什么的没法比。人中毒以后总要有有一个恢复的过程，这个中毒用甘草汤来治就恢复得很快。

另外，现代医学证明中医中药也是有毒副作用的，这也确实。说明这个药有增液的作用，换一种说法，它有减缓人体体液代谢的作用。中医界对甘草最常见的诠释就是“调和诸药”，这种说法初看有一定的道理，但是如果整体来分析经方 260 多首方剂，含有甘草的方剂占到了 127 首，还有百分之五十以上的方剂没有甘草，如果甘草可以“调和诸药”，就无法解释这些没有甘草的方子，为什么不需要“调和”？如果我们客观地来看这种结论的负面影响，它可以误导读者，加一味甘草几乎就成了一种下意识的，理论依据就是可以“调和诸药”。这种做法也不对，因为还有一百多个经方用不到甘草呢。

甘草汤方证在临床中症状表现：腹痛、纳呆食少、腹胀、咳嗽、神疲乏力、胸痛、低热、恶心、呕吐、自汗。统计资料里没有治咽痛的，这不等于不能治咽痛，而是用得少，没统计到医案。

舌质：舌细嫩无苔，这样的比较多，也有苔黄燥的，因为医案比较少，也没有分明显的舌质、舌苔。

脉象：沉、伏、细、数。

应用这个方剂治愈的现代疾病：胃痉挛、胃溃疡、野蕈中毒、木薯中毒、肉食类食物中毒、渗出性胸膜炎、克山病、口腔溃疡、阴部肿痛、痔疮、脱肛、皮炎、天疱疮、圆形脱毛症、盘形红斑狼疮、苔斑、黑皮症。现代疾病里有一个很特殊的“舌肿大”值得说一下，就是人的舌头突然肿大、满口、塞喉，舌头肿大的在嘴里差不多要盛不下了，气息不通，这是一个比较特殊的病。但是甘草汤治愈的疾病里有这类疾病的记录，我觉得可以给大家在临床应用中提供一个参考。

接下来是桔梗汤。桔梗汤有两味药：桔梗、甘草。可以把它看做甘草汤加桔梗。桔梗药性微温，有排脓、利咽、宽胸的功效，可以治

疗胸痛如刺、脓吐、脓血痰、咽中肿痛。

从它的临床应用看，治疗的主要是单纯的咽喉部位肿痛。从理论上讲，如果同时伴有桔梗汤适应证的其它病，比如肺痈同时有咽痛的情况，用这个方剂是不二的选择。但实际临床中更多的表现是单纯的咽痛，并没有那些肺部的症状。所以理解甘草汤证和桔梗汤证的这个“咽痛”，应该是这两个方证中一种比较特殊的症状反应。因为这两个方剂的适应症，临床中常常表现就是一个咽痛，没有那一大堆的症状，它也可以用这种方法来治疗。

桔梗汤证在临床的症状反应：咳喘、胸胁痛、咽喉痛、咳出脓血痰、发热、食欲不振、口燥咽干、形体消瘦、便秘、盗汗、尿黄、神疲乏力、面色不华。

舌质：红舌、淡舌，以红舌为主。

舌苔：白苔、黄苔，以白苔为主。

脉象：数脉、滑脉，以数脉为主。

有应用机会的现代病：肺脓疡、急慢性咽炎、急性喉炎、咽喉肿痛、急性会厌炎、扁桃体炎、扁桃体周围炎、结核性脓胸、支气管扩张、大叶性肺炎、支气管肺炎、梅核气。

少阴病、咽中伤生疮、不能语言、声不出者、半夏苦酒汤^①主之、（312）

注：“半夏苦酒汤”《宋本》作“苦酒汤”。

半夏十四枚洗破如枣核 鸡子一枚去黄内上苦酒·着鸡子壳中

右二味、内半夏、着苦酒中、以鸡子壳、置刀环中、安火上、令三沸、去滓、少少含咽之、不差、更作三剂、

胡希恕：这一个就重了。你看他搁个“咽中”，“咽中者”就是

整个嗓子。而且生疮，啊，就是有溃破的地方。那么这一个就近乎这个化脓之候了，是吧？“不能语言”，这一个重的很，啊。他这个不能语言呐，有几种，一种是疼的厉害，一种啊，就是这个，缠…啊，这个粘痰呐，啊，胶着这个嗓子这个地方，吞吐不出。这个…这个…这个嗓子那疼的厉害，所以“声不出”。苦酒汤主之，啊。这一个法子也挺妙。这个半夏这个药啊，在古人说它是一个下气治咽痛，啊。它这个以半夏为主的。它搁十四枚，啊，他是重用这个半夏了。“鸡子”，就用鸡子清，啊，把黄儿去了。它这个煎法也挺别致。他用这个，把这黄儿去了，它那清儿还搁到那个鸡蛋壳里头，那个壳儿里头。然后啊，啊，它底下有…有说法，“右二味以半夏，着苦酒中，以鸡子壳置刀环中”。他这个意思是什么意思呢？他就是把这个鸡蛋壳里头，搁上苦酒。苦酒就是醋。那里头还有清儿嘛，连鸡蛋清儿，啊，带苦酒，然后把这半夏也搁里头。他这古人，他是利用这一个，啊，当时的器皿。这也是个秘方大概，古人也有个说法儿。那个刀啊，后头都有一个环儿，那个，早头儿那个，那个…那个腰刀，他那后头都有一个把儿，把上有一个，有一个圆的，啊，他为之绑这个绸子、穗子什么东西的。他这鸡蛋呐，正好搁那里头，掉不下去，它那环儿也不大，啊。然后啊，把这个搁到火上，他利用这个，就是利用这个鸡蛋壳。“令三沸”，你要功夫多了，这鸡蛋壳就糊了，是吧。哎，一看开三开就行了，把这个滓子啊，不要了。“少少含咽之”，因为这个，他少少含咽之也有用意的，让这个药啊，老…啊，长久的在嗓子这一块儿存在。咱们吃六神丸也一样啊，啊，六神丸也不能一下子都咽下去呀，得含着，是吧？那么它这一个呢，少少，一点一点的润，啊，在这个嗓子这个地方。“不差，更作三剂”，假设吃一次，啊，都是这个做法，不好，可以连下做，吃到三剂，大概可以好的，啊。这个鸡子清这个药啊，啊，这个，这个，啊，它是出音声的。咱们以前的这个，唱戏的人都知道，嗓子不好了，他在后台上就是喝，喝个

鸡蛋清子，啊，马上嗓子就痛快，啊。所以这个，这个方子很妙，啊。它这个醋呢？它是收敛，敛疮疡。这一个较比以前的这个嗓子是重了，啊。

李冠杰：这是降一字格排版的条文。

“半夏苦酒汤”在《宋本》里边把“半夏”两个字去掉了，就是“苦酒汤”，这个也没什么原则问题。

下面解读一下：

“少阴病”，在这可以理解为由少阴病发展而来。

“咽中伤，生疮”，就是咽喉部位发生溃烂、溃疡之类的病变。

“不能言语，声不出者”，临床当中这是表现比较近似的两个症状反应，但它们之间存在着一定的差别。“不能言语”，主要是指咽喉部位因为疼痛比较重而致患者不敢说话，一说话就会造成咽喉的疼痛；“声不出”就是声哑，想说话，但是却发不出声来的这么一种症状。这实际就是现代病当中的声带水肿之类的疾病。

“半夏苦酒汤证”的病理：是半表半里的虚热证。

下边做个小结：少阴病，症状表现为咽中伤、生疮、不能言语、声不出的，为半夏苦酒汤主治之证。

这个方剂由三味药物组成：半夏、鸡子清、苦酒。半夏寒热倾向不明显，性平，它是一味以降逆、去饮、化痰为主要作用的药物，它同时还有治疗咽喉部位疾病的特殊的功效。这个方剂正是用了半夏的这种作用。鸡子清是鸡蛋去了黄，剩下清了，有清热利咽的作用。苦酒就是米醋，它性寒，有清热和收敛的作用。

这个方子的煎制方法比较特别，方后注解基本写得比较清楚。为了把这个问题弄得更清楚一点，我们举一个后世有人对这个方后注解提出的疑问。咱们通过这个疑问，我们来澄清一下这个方后注解当中一些问题。

有人认为方后注解不合逻辑，因为十四枚的半夏本身就比一枚鸡

蛋的体积大，而且鸡蛋去了黄以后，鸡蛋清也要占到鸡蛋的体积的将近一半，再加上苦酒，一个鸡蛋壳根本就容不下。这种理解、这种读法提出这种疑问，就说他动了脑子了，但是这其实是一种误解。你仔细去品品这文字，“内半夏、着苦酒中”，前边有“右二味”，就是将半夏破成四瓣，实际上就将半夏弄碎了，“内半夏”，将鸡蛋弄一个洞，全部倒出来把黄去掉，剩下蛋清，将半夏和蛋清混合了。然后再跟醋混合。最后将既有半夏、又有醋也有鸡子清的混合物倒入鸡蛋壳里边，鸡蛋壳里边能盛多少就倒多少。实际就这个意思，只能这么解释。按别的解释，它就不通啊。

实际临床还有其他的做法：先把半夏和醋，先煎了，煎好以后把半夏去掉，加入鸡子清，因为鸡子清一到沸点就熟了，就像鸡蛋花一样，这没关系，一样能治病。

“半夏苦酒汤”方证：

症状：咽痛、声音嘶哑、咽喉干燥，主要这么三个症状。声音嘶哑里边，应该包括“失音”，不仅仅是一个嘶哑的问题，有时候说不出话来。

舌质：红舌，有舌质记录的就一个医案。

舌苔：有白苔、腻苔、滑苔。

脉象：数脉、滑脉、虚脉、细脉、缓脉。

现代应用：声带水肿、咽喉水肿、咽喉溃烂、咽喉结核、慢性扁桃体炎、失音、急慢性咽炎、咽部溃疡、口腔溃疡。

治咽痛的方子集中在这儿，我给这个方子挑了一个挺有意思的医案，能帮助大家来理解这个方证。

一个 16 岁的小男孩，是个晋剧演员，突发失音。你想唱戏的人，发不出声音，这就成大问题了。话都不能说，经过医院诊断，是声带水肿。用青霉素、链霉素，以及服清热消肿利咽之类的中药六剂，都没效果。后来就用半夏苦酒汤，一剂后声音豁然嘹亮（这叙述得非常

有意思），共服三剂，痊愈。后再未犯。大家看看这就是经方的疗效。他这就是一个声带水肿。

少阴病、咽中痛、半夏散及汤主之、（313）

半夏_洗 桂枝_{去皮} 甘草_炙

右三味、等分、各别捣筛已、合治之、白饮和、服方寸匕、日三服、若不能散服者、以水一升、煮七沸^①、内散两方寸匕、更煮三沸、下火令小冷、少少咽之、（注）半夏有毒・不当散服・

注：“煮七沸”《宋本》作“煎七沸”。

胡希恕：他都大量用半夏。那么这一个呢？他是外有风邪。所以他用桂枝甘草汤的基础了，加半夏。那么这一类的嗓子疼啊，这都是特别凶。他也写个“咽中痛”，啊，他不是个“咽痛”了，全嗓子都疼，啊。这一个古人呐，管这一种的嗓子疼啊，叫“缠喉风”啊，啊。这一个现在不常见。这个说…啊，说死就死人的。这个喉肿得也厉害，这个咽喉，啊。那么有这一种这个痰涎缠绕。这个相当的凶，所以这一个，啊，他也有，也有外证，不是没有的，所以他用桂枝甘草汤呢，他也是解外，同时以大量的半夏，啊，啊…来治这个嗓子肿痛。这一个半夏治…治咽痛，这古人说…桂枝也治咽痛啊，桂枝这个药啊，你们看看那个《神农本草经》上有“治喉痹”，啊，就是咱们痹疼那个痹呀。这一个后世甘草汤没有。所以这个桂枝这个药也…也止痛，啊。所以身疼痛没有不用桂枝的嘛。它也治喉痹的这一种痛。那么这个药这是…啊，现在很少有人用了，遇着这个嗓子疼啊，大概都是在这个解热一方面，滋阴解热这一方面下手了。但是有这个病呢？就我认为还是…还是要用这个方子，还是能好的。他说这三味呀，

“等分，各别捣筛已”，啊，要捣，要是…所以各别捣筛已者，就是要捣碎、筛细的意思。“合治之”，然后捣到一起。白饮和，服方寸匕，日三服，若不能散服者，以水一升，煎七沸，内散方寸匕，更煮三沸，下火令小冷，也是少少咽之。啊，不是像咱们…，啊，因为这少少咽之，因为使这个这个药啊，老存在于喉间。这个半夏起这个作用。那么后头有注了“半夏有毒，不当散服”，这生半夏了，啊，生半夏是有毒的。现在咱们这个半夏啊，都是制的，啊。也有拿姜制的，啊，也有拿矾制的还，啊。拿姜制是最好，那也跟生半夏差不多。但是毒…毒可就没有了。那么这以前呐，都是对这个咽痛，他出这些方子。当然这个也不尽这个咽痛之治，是吧？所以我们要对于咽痛呢，头前儿这两个小方子常用的。这个咽中生疮，啊，用这一个苦酒汤，啊…这一个我试验过，啊，就是人这个嗓子疼，声不出，的确这个鸡子清是起作用。后边这个我没用过，啊，但是嗓子痛以后边这两个为最重。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降一字格排版的条文。

解读一下：

“少阴病”，可以理解为这个方证可由少阴病发展而来。

“咽中痛”，虽然较前几条条文的“咽痛”仅仅多了一个“中”字，但是在发病部位上，跟“咽痛”明显有更偏于里部的意思。

从这个方剂有治疗食道炎的记录来看，这儿的“咽中痛”不仅仅是咽喉部位的病变，还应该包括咽喉以内以及更深部位的疾病。

另外，这个方剂中包括了桂枝甘草汤，所以这个方剂的适应证，应该不是单纯的咽喉部位的症状，常会伴有表虚证的某些症状反应。而实际临床应用当中，也证明了这一点。

“半夏散及汤”的病理：是表虚证合并半表半里证。

这个半表半里证我没有定是虚还是实，是热还是寒，没定。因为药味比较简单，寒热倾向都不明显。

半夏散及汤由三味药组成：半夏、桂枝、甘草。可以视为桂枝甘草汤加半夏。

它的适应证，也不外乎阳性表虚证而以咽痛为突出症状反应的一种疾病。但是从寒热属性上分析，这个方剂，属性应该略偏于温。所以适应证，也应该略微偏于寒或者没有明显的寒热倾向。在这一点上，跟前面几个条文论述的“咽痛”，在病理上这是明显的差别。

方后注解有“若不能散服”，有这么一句话。但是到《宋本》里边，看不出是注解，这就成了矛盾。本身就是既能做散又能做汤的一个方剂，后边又特别说明了“半夏有毒，不当散服”。这不是矛盾吗？我在当时还没见到《康平本》的时候，我就曾经跟别人说过，这后边这个是后人加的内容。

那么这个“若不能散服”，指的是什么呀？生半夏对咽喉部位刺激非常大。但是实践证明，我在临床当中感觉就非常明显：不同的患者，半夏对咽喉的刺激程度也不同。

这也奇怪啊，用相同的剂量，相同的方剂，有的人喝了就说，我喝了以后就跟得了喉癌一样难受。但是有的人就说，我不觉得怎么样啊。所以，不同的患者之间差异比较大。这儿的“不能散服者”，就是指的对半夏刺激比较敏感的那部分病人，那就变个方式，可以改成汤嘛。不但方后注解有要求“散服”的明文，而且在临床当中证明半夏完全可以作散剂服用。半夏所产生的副作用主要是对咽部和胃部的刺激。比如半夏厚朴汤，半夏的量就不少，如果当散服，服到胃里后，短时间胃里边也有一段时间难受。不是特别难受，明显感到刺激胃。事实上，如果是生半夏，就是做汤，这种刺激作用也还是比较明显的。不然的话，制半夏何来？实际上制半夏就是为了克服这个问题，用矾制也好，用姜制也好。我现在用半夏，就是自己用姜制。

但是有一个共同的问题，就是在不同的患者身上，刺激的程度不同。原文里边那句话就是这个意义上的。

那么，这个方剂在剂型上，在经方里边是最具有典型意义的一个方剂。这个方子既能做散服，又能做汤剂。这就提示我们，经方当中的其他方剂，也完全可以如法炮制。

当然，我当初也没有学得这么深入，当初我把汤剂改成小剂量的散剂，经历了一个比较长的过程。那是长时间的一个夙愿。很早我就感觉到中药这种剂型，一定要进行改革，太麻烦。

很多人在看病的过程当中，一说，有的人就直接先问我需要喝汤药吗？我没法熬汤药哇，不是不想喝，就是太麻烦了。后来，慢慢自己探索，等这一套东西形成了以后，我再带着这种理念，再回过头来，再细读经方的时候，唉，慢慢的在里边找到了好多的证据。不单单找到了好多证据，就是把整个经方药量的问题全部给理顺了。

那么这个方剂，就非常有力地证明了我现在用的这种小剂量散剂，其实，古人以前就这么做过。但是，为什么没有延续下来呢？因为在当时做散、做丸剂是一个很麻烦的事情。没有粉碎机，把那个药物，不要说弄碎了，就是切饮片都很困难。所以在汉朝那个时候，那中药都是一段一段的，这个，我们都论证过。

那么，咱们今天把药粉碎已经变得非常简单了，明明古人已经给我们示范了，我们没有理由不去做啊。我现在所有的经方系列的都做成散，用开水一泡，然后就直接服用。一般临床当中，现在大约在两三克左右，一般的病都是这么个剂量。那么跟这个地方的论述，是完全吻合的。那么这个事，我也不是一下就到位的，经过了好几年。逐渐地临床当中去体悟，去收集病人的反映，包括我自己服药，自己的感觉，最终，形成了体系，成熟了。也没跳出经方理论，还是这一套东西，只是理解得深度不一样，角度不一样。

那么，半夏散及汤的方证：

症状：咽痛、恶寒（有表证的反应）、声音嘶哑、痰涎清稀、呕逆。

舌质：淡舌、红舌。

舌苔：白苔、黄苔、腻苔、滑苔。

脉象：细脉、浮脉、滑脉、沉脉、缓脉、数脉、濡脉、弦脉。

现代疾病：慢性咽炎、急性扁桃体炎、扁桃体及周围炎、呼吸道感染咽炎、咽喉炎、食道炎、食道癌初期、支气管炎、支气管哮喘。

这儿，我给大家找了一个半夏散及汤的医案，跟大家说一说。一位女性患者，身体平素就比较弱，有这个痰咳的宿疾，常好吐痰咳嗽。患病的时候，因为家务事比较重，造成心理和体力都比较疲惫。那么，引发恶寒，发热，头痛这一类的症状，尤其是咽痛比较剧烈，以至于造成卧床不起，吞咽困难；脉是两个寸脉浮缓，咽部色不变。大家注意这一点，咽部色不变。但是，咽部疼得挺厉害。就给了她半夏散，让她服散，而且是徐徐地咽下，慢慢地咽下，就是能作用于发病的咽喉部位。服两剂，寒热、痰咳、咽痛等消失。之后，就用的是扶正的药，因为她体质比较弱。这个医案里边，她有明显的表证，这是一个特点；另外一个咽部色不变。这提示我们，这个半夏散及汤治疗的还有这一方面的倾向，就是还有时候，咽喉部没有红肿之类这种反应。

少阴病、下利、白通汤主之、（314）

葱白四茎 干姜一两 附子一枚生去皮破八片

右三味、以水三升、煮取一升、去滓、分温再服、

胡希恕：这一个“少阴病下利”，这就在，跟那个头前儿咱们讲那个“太阳阳明合病，必下利，葛根汤主之”是一样的道理。那一个“必下利”也不是说太阳阳明合病必定下利，不是这么个解释，啊。这一个书里头有很多这一种，这一种话。你像说，像咱们讲那一个，啊…桂枝汤证“头痛者必衄”跟这一个，啊，“太阳阳明合病必下利”是一样的。他是冲着这个方剂上说的。说太阳阳明合病，得怎么合病

呢？必须有太阳病，同时有下利，必须得这样子。没有下利，你，那太阳阳明合并那个，那个证候多去了，不一定得下利呀，必须有下利，才能用葛根汤主之。像我们说那个头痛，不是说凡头痛，就要鼻衄的。如果头痛而鼻衄者那用桂枝汤。因为桂枝汤这个应用啊，全是在这个津液丧失之后，你比方自汗呐、时汗出啊，啊。那么这个鼻衄呢？也丧失，丧失津液，丧失阴液嘛，啊。他因为他那个药啊是甘温，啊，养胃、益气的这么一种作用。那么这一个跟我们说那个葛根汤是一致的。少阴病同时有下利。少阴病也是个表证啊，这个下利以表证出现，这个病还是要欲表解的一种反应了，所以他用白通汤主之。那么白通汤是个什么药呢，你看看这个方剂就知道了。“葱白四茎”，那么四根葱白这很，很大的分量了，啊。“干姜一两，附子一枚”。这个葱白是个发汗药，辛温、发汗。那么搁上这一个，啊，温中，啊，亢奋机能的药“干姜、附子”，这是个大…大热药了，它治阴证的。跟我们那个，头前儿讲那个麻黄附子甘草汤、麻黄附子细辛汤，是一样的。这也是个少阴病的一个发汗的方剂。由于干姜、附子，啊，温中都有治下利的作用啊，所以他用这一个发汗，发少阴，啊，这个表证之汗，这个利当自止。这跟那个葛根汤，啊，治这个“太阳阳明那个合病”是一个手段。那么我们遇到下利呀，啊，有这一个，又有这个太阴病脉浮者可发汗宜桂枝汤”与这个太阳阳明合病，必下利而用葛根汤”，都是一样。说明在临床上啊，遇着下利，如果有表证，要是有，现无汗的这一种脉浮紧的这一种情况，用葛根汤；如果汗出脉弱，那就要用桂枝汤；如果现少阴的这一种情况，啊，脉反而微细，当然也有这个表证存在了，是吧？他要用这个白通汤。但是这个下利没有表证，那千万不能用这个方子，那一个方剂…所以中医就是讲辨证，不是说发汗能治下利，下利而以表证出现者，那你就要发汗。所以这一个方剂呀，它是个发汗的法子。因为这个，豉，啊…这个豆豉加上葱则发汗嘛，是吧？葱豉汤。一般的解表，啊，这是见《千金》

的方子。那么，我们家乡就常这样子，就用点葱，用点姜，搁点红糖，搁点草叶儿什么的，感冒了，这乡村它这个药困难，就拿个东西熬熬喝了就好了。右三味，以水三升，煮取一滓，啊，煮取一升，去滓，分温再服。我们因为什么讲 这么详细呢，就为了下边这一，这一段，你们好好看看下边这一段。

李冠杰：这条在《康平本》为顶格排版的条文。

解读一下：

“少阴病”，在这条里指的是真正的阴性表证。但这个方证不是单纯的少阴病，而是少阴病与太阴病合病。所以这儿的少阴病可以理解为：这个方证常由少阴病发展而来，不单单是出现了太阴病，同时少阴病也还没有结束的一种情况。

“下利”，是这个方子的一个突出症状反应。此时的下利已经不再是以少阴病为主要病理的，不是以阴性表证为主要病理的情况了。不在阴性表证的情况下但见下利的一证，而是以阴性里证为主要病理的一种下利，同时又存在着阴性表证。这时的患者不单单有阴性证的典型症状反应，像“脉微细但欲寐”这类的，同时也会伴有消化道内的一些疾病，比如下利清谷，这都是完全有可能的。

从方证和病理上分析，这个方证实际上就是桂枝人参汤证而陷于机能沉衰的阴证。如果是桂枝人参汤证现阴证的话，就在那个方证的基础上加附子就行了，但它们还有一定的区别的。由于历代的注家都以《内经》的经络理论来解释经方理论，都将少阴病理解为心肾经的疾病，所以临床中这个方剂的应用率就很低。因为在没有表证时用这个方子是很危险的，这个方子对那种疾病都是一种重症，如果没有表证不要轻易吃这类药，胡老说过没有表证的话，不要轻试这味药，就是这意思。因为这本身就是一个重症患者，没有表证而吃了解表的药，会出汗而丧失津液，对人体有很大的损伤，可能会出现医疗事故的。

那多数的医案都是治疗的什么？治疗的确确实实是这个方证，但

都是重症。因为到重症的时候，其它的方剂治不了，就得用这个方子治大病。从医者写的辨证思路看，辨证是错误的，但用的方剂是对的，大部分都是歪打正着。病人确确实实是既有表证又有阴性的里虚寒证，但是多数医者理解成是心肾如何如何，这种解释是不对的，但是方子是对了病治好了。因此，临床中用好这个方剂的不多，统计到的医案也不多。其实仔细看看这个方剂，不都是像统计到的医案把病说得都那么重，这个方子就是干姜附子汤加上葱白，就干姜、附子、葱白三味平常的药，葱白和麻黄桂枝相比要平和得多，并不一定非得在危重的情况下才用这个方子，只要符合这个方剂的病理特征，而且表现为这种症状就可以用。

白通汤证的病理：阴性表证合并里虚寒证。

做个小结：少阴病同时以下利为主要症状表现的，为白通汤主治之证。

白通汤由三味药物组成：葱白、干姜、附子。葱白是一味温性的药，有温中发汗解表的作用，干姜、附子实际就是一个干姜附子汤，再加上葱白就是这个方子。所以这个方剂的适应证，其实也就是干姜附子汤证，又有表证者。干姜附子汤证在太阳篇第 61 条中的论述：

“下之后，复发汗，昼日烦躁不得眠，夜而安静，不呕，不渴，无表证，脉沉微，身无大热者”，这就是干姜附子汤证。“不呕，不渴”是指没有少阳病和阳明病，“无表证”就是指又没有太阳表证，在那条里就是这个意思。但是白通汤证，正是在这个基础上伴有阴性表证的一种情况，“不呕不渴”在这儿没有意义了，在这个基础上把“无表证”变成伴有表证，就是这个方证。所以这个方剂并不是一定在危重情况下才可以用。

一般情况下，当人体处于里虚寒的状态时，通常不会再表现为有浅表性的症状反应。这个问题实际是个比较好理解的，我常举这个例子：在医院里经常有做外科手术的病人，特别是腹部手术把整个腹腔

给剖开了，做完手术以后缝合，人满身插着管子在观察室里边停着，尤其是冬天的时候，医疗条件不好的医院观察室里的温度还挺低，这样的病人没有一个患感冒的。因为病人所有的能量都集中在手术区域顾护里边了，没有能力在浅表层与疾病作抗争了。但是也有一些例外的情况，像白通汤证和桂枝人参汤证都属于这类的情况：一方面里虚寒证比较严重，造成下利；另一方面还表现为一定程度的表证症状。这个白通汤证是典型的阴性证，它比桂枝人参汤证机能沉衰得还要厉害！在这种情况下人体仍能表现出表证的一些症状反应，就常常会表现出来中医里称之为“格阳”的一些特殊症状反应，比如里虚寒证厉害，但又表现为像颜面潮红、目赤等类似于热证的一些症状，这应该视为人体机能沉衰到比较严重的程度，而表现出来的一种反常现象。

白通汤方证主要的症状统计比较详细：四肢厥逆，往下依次是神昏、发热、食欲不振、烦躁、腹痛、出汗、唇肿而焦、渴喜热饮、下痢脓血、气促、心胸烦乱、头痛、腹泻、目赤、小便短赤、呕逆、面色潮红。

舌质：淡白、胖嫩、淡紫、青紫、胖大有齿痕。

舌苔：薄白苔、白滑苔、厚腻苔、黄黑苔、燥苔、无苔。

脉象：沉脉、微脉、细脉、虚脉、紧脉。

应用这个方剂的现代疾病：高血压危象、过敏性休克、乳腺炎、类风湿、麻疹、急性肠炎、痢疾、雷诺氏病、前房积脓（这是一个眼科的病）、妊娠厥逆、心力衰竭、尿毒症、肝昏迷、霍乱、肠伤寒。因为这个方剂因为理解的问题，临床应用有一定的误差，所以这些现代疾病仅供参考。

少阴病、下利脉微者、与白通汤、利不止、厥逆无脉、干呕烦者、白通加猪胆汁汤主之、（注）服汤・脉暴出者死・微续者生・①

注：《宋本》此处有“白通加猪胆汁汤”七字。

葱白四茎 干姜一两 附子一枚生去皮破八片 人尿五合 猪胆汁一合

右五味、以水三升、煮取一升、去滓、内胆汁人尿、和令相得、分温再服、（注）若无胆·亦可用·

胡希恕：“少阴病，下利，脉微者，与白通汤。利不止，厥逆无脉，干呕烦者，白通加胆汁汤主之。服汤脉暴出者死，脉续者生，”白通加猪胆汤…啊，脉续者生，就完了，啊。这个白通加猪胆呐，他搁到上边儿那个主之…之后附的方子了。那么这一段是有问题的。历来注家都这么说的，啊，我们先根据这个，你们看这个《伤寒论》其它的注家，他们全是一样，他说少阴病下利，脉微者，应该用白通汤，啊，同上面一样了。那么吃上白通汤，利不止，厥逆无脉，干呕烦者，这不是药有所误，这是因为这个病啊，太寒了，冷不丁给吃热药，反而不受，拒而不受，所以发生这一类的情形。得怎么办呢？他古人有一个说法儿。说得呀，热以寒用，说这个药太热了，加点寒药，加点猪胆，啊。这样子一吃，就可以好了。这一个说的是…我以前也是信来，啊，我学伤寒的时候，也这样子，其实这是大错啊。怎么错呢？你看看这个本文，啊。他头前说少阴病下利，没说脉微呀！那么这一段他，他搁个“少阴病，下利，脉微者”，这一个不得与白通汤。与白通汤，不但利不止，而且出来底下这一个逆治的，啊，这是个坏病的样子了，厥逆无脉，干呕，烦。而且这个病，有生死的关系了，你看后来，你看一看，就吃这个药，“脉暴出者死，微续者生”，这多么严重啊！……无阳就没有津液，外边没有津液，不能发汗，一发汗，再使着亡阳，虚极一定转入这个，啊，阴寒重证，那就是底下这种情况。所以这一个，这一个因为什么注家象…，方才我说那么个解释呢？他们就认为，把这白通汤认为不是发汗药。哎！他看看葱

白呀，啊，也是辛温嘛，可是真发汗。咱们这个大葱谁都知道啊，是吧？如果脉微，无阳，不能发汗。那么即便他有利，那也只能救里，不能够再攻表。所以“与白通汤”这是个误治啊！不但“利不止”，而且厥逆无脉，啊，干呕，烦。“厥逆无脉”他是虚脱的样子了。以前他并没“厥逆无脉”呀，你看看。这是吃这个药加重了，那是个，哪是个，啊，格拒不受的样子，不是的！可是以后这个白通加猪胆汁也有问题了。那么既是这样子，还能够用白通加猪胆汁汤吗？我认为这一个也错的。这个应该是通脉四逆加猪胆汁。这后头有，啊。这个“厥逆无脉”，他是，得用通脉四逆呀，哪有还用白通汤的？白通汤还发汗呐，再发汗他非死不可！那么加猪胆汁，也应该加到这个通脉四逆汤里头，不能加到白通汤里头。你们好好，好好研究研究这一段，啊，这是我这么讲。应该是通脉四逆汤，这个白通加猪胆汁汤啊，这是个错误，传抄错误。因为他这个书啊，现在差不多一千七八百年了，他开始他没…没有这个，啊，印好的这种现成的书，都是传抄，都是抄，你借我，我借你，他这个书，啊，并不普遍。这把这个白通加猪胆汁，啊，应该是通脉四逆加猪胆汁这么搞错了。那么你看看后头就知道了，唯独通脉四逆汤才能复脉的嘛。可是这个复脉，脉暴出，脉暴出怎么死啊？这就像这一个，咱们这个灯，啊，早时候油灯最能看出这个了。油没有了，这个灯就骤然间一亮，可就灭了，啊。所以这个灯欲灭而焰反彰嘛，啊。这是一般的常识，拿这个他做比喻。“暴出者”就是虚极暴脱的样子。虽然脉一出，马上就没有了，这非死不可。“微续者生”，一点一点这个脉往回恢复，啊，这是生气欲复之象，所以他必活。所以这个白通加猪胆汁啊，应该通脉四逆加猪胆汁。怎么讲呢？你看后头这个方，这个方剂的作用就看出来了。那么如果这个虚寒到了极点，咱们要去这一种沉寒，扶阳，非附子干姜不为功的。他这个书的前后就可以看出来。那么这白通汤你看看干姜附子，用量比较轻。那比这个四逆汤还轻，比通脉四逆它更比不了。那么已

经“厥逆无脉”而用这一个分量就是不行。你再加上发汗那不更不行了吗？是不是？所以这一个我认为这是很成问题的。那么这个书呀，可也都是这么，啊，这么撘着。我现在这个，啊，注…注解这个书的时候，我把这个，啊，有些话说得挺那么多，都把它改了。那么搁这个猪胆汁，这个药是什么个药呢？这个药啊，是个苦味亢奋药，有些亢奋作用。但是加也不能加到白通汤里头。这个人尿，啊…在白…在通脉四逆汤里头没有人尿啊。这个人尿也，也，大概也起亢奋作用吧。这，咱们现在来说，或者是，它也有这个…里头多少有荷尔蒙，啊，有这个激素，啊。这一个咱不敢说，这一个这因为科学没有考验。可这个人尿呢，的确治这人一时的虚脱。这一个咱们旁的没看着，啊…有的时候这个，啊，这个妇人产后昏迷，常用这个童子尿给她灌，啊，有时候他解决问题，啊，这个我也亲眼看着过。那么这个需要研究了，是不是这个药有…有这个作用。像我说这个，是不是里头有，啊，有少量的激素，这也不一定的。那么就加这些药，加胆汁和人尿，也要加到通脉四逆，也不能加到白通汤治这个病，啊。这一个我肯定。因为他不对头嘛。他特意搁个“脉微”不是随便搁的呀。头一个“少阴病，下利”，他合病，有少阴病又有下利，当然脉不是微了；这一段他特提出个“脉微”，这不是随便说的，啊。那么注家把这个“脉微”呀，也给抹了，那么把这个，就认为前后是一个病，他不是一个病。所以这一，这一段呐，很成问题，啊。你们好好看看那个，各注家，自己再好好考虑考虑，啊，值…这一个值得研究的，这一段。

李冠杰：这是个顶格排版的条文。

《宋本》里边在条文最后有“白通加猪胆汁汤”七个字，《康平本》里边没有。

下边我们解读一下：

“少阴病、下利脉微者”，这儿论述的跟 314 条的情况非常相似，但是这儿却强调了一个“脉微”的症状。说明这个条文里边论述的，

虽然也是阴性里虚寒证合并阴性表证，但却是一种病情重于白通汤证的一种情况。

“与白通汤，利不止，厥逆无脉，干呕烦”，它本来就是一个白通汤证，但是服了药以后，不但下利没能止住，而且还出现了“厥逆无脉、干呕烦”这样危重的症状反应。为什么出现这种局面呢？只有两种可能性：一种是方不对证，另一种是方剂未能起到应有的疗效。从后边用白通加猪胆汁汤来治疗来看，第一种可能性可以排除，肯定不是方不对证。第二种可能性原因何在？为什么用了对证的方子却没有取得应有的疗效呢？这个地方涉及到一个很重要的问题，中药治病的机理的问题。中药治病，它并不像现代医学所研究的药物机理，跟那个不一样。现代医学是某种药通过某种机制可以控制某种致病因子，说控制也好，杀灭也好。中药治病，则是用的它可以对人体内环境所产生的影响的这个作用。换一种说法：中药有干预和调整人体能量分配机制的作用。这是我的理解，供大家参考。其实我们中医在这方面有很深的体会，但是说法不一样。比如我们用中药治病，用的是中药的偏性，如果进一步地去研究它的偏性对人体产生什么作用，最终还应该落到这一点上。

下边以一味中药作例子，咱们来解析一下：

水蛭，它的临床应用就可以充分说明问题，现代医学也认识到这个药，它是一味有活血化瘀功能而且这个功能非常强的一味药；中医看它还是一味性偏寒的药。活血化瘀的作用比较容易理解：水蛭本身就是以吸食血液为生的一种生物，它每在食血之前，都先用它的唾液稀释被它吸食的对象血液，它有这种本能。一般认为，就是因为这个它就具有了活血化瘀的功能。但是这还是比较浅层面的。我们进一步分析，作为我们应用的水蛭是中药饮片，唾液已经干枯了，生命已经消失了，仅余一具干尸，不单是每次所用的量非常的小，还常是用来把它煎成汤。不吃它本身，用水煎出它的可溶物。那么吃多少啊？

我们先说一个剂量比较大的，像抵当丸。抵当丸水蛭用了二十枚，干燥的饮片中等个的，大概一枚就一克左右，这就是二十克左右。但是抵当丸每次只用其中的四分之一，也就是说只用了五克左右，而且这五克左右实际上是煮水喝的。再来看看大黄廑虫丸，大黄廑虫丸把所有的十多味药都计算在内，每次的服用量也只有小豆大的丸剂，五粒，而且这里边还有黏合剂，总重量应该不超过 1.5 克，其中这几味活血化瘀的药都加到一块，也只有零点几克，具体到水蛭这一味的话，重量就少得可怜了。但是如此之少的药量，只要是对证，不单单可以治病，而且可以治大病，治重病。大黄廑虫丸本身就是一个比较重的病。这不能不令人深思啊！从这儿我们就可以感悟到：中药治病并不是这个药物直接在起作用，而是利用了药物对人体所产生的影响。

在临床当中有一种很特殊的现象，至少跟现代医学在这方面是反着的。越是病重而且人虚的这种患者，中药的用药量越小。我记得跟大家不止一次地说过：山西名老中医李翰卿就用总量 3 克左右的真武汤加减，而且还不是粉剂，他用的饮片，治疗的是一个严重的心脏病患者。而且在他用这个方剂之前，有其他的中医开了类似的中药方剂让这个病人喝，他是用的正常的量，患者喝了以后马上病情加重，甚至都出现危重。这就说明中药治病的机理是干预人体自身的能量分配。当人体能量极度虚弱的时候，你大剂量的药物摄入人体之后，他无能量可调动，没有能量可干预，而且这个药物本身也就成了人体的一种负担了，它不单单起不了应有的作用，而且成了一种负担。

咱们回过头来，再看看白通加猪胆汁汤这个方剂，它就是这一类的情况。因为病情急迫，古人总结出了另一套办法，他没有用减小剂量的办法，同样也可以解决此类问题的办法，就是在原方的基础上加入猪胆汁和人尿。这两味药虽然说都属于偏寒性的，但是都有亢奋人体机能的作用，可以强心、止呕、除烦，在振兴人体机能方面，有其它任何药物无法替代的功效。而且这还只是从经方应用这两味药物当

中，咱们总结出来的这两味药的作用。在经方以外的应用当中，这两味药还有其它的功效，比如人尿这一类的，拿来入药让人感觉到非常恶心，但是你看南方不有童尿煮鸡蛋嘛，是作为食品来吃，而且还成了名吃。从事实上看，目前人类对这一类药物的真正认识还非常肤浅，但是有一点是明确无误的，就是当干姜附子剂对证治疗而效果不佳的时候，加上这两味药就可以取得理想的疗效。至于其中的机理，还有待于进一步地研究。不仅仅经方里边有这样的经验总结，经方以外的中医里边也有这样的总结。

这儿就有一些东西值得我们去思考的：比如以前药农进山去采药，有时候在半山腰，滑落下来，有的就摔得休克了，跟他同去的人，好多人就知道这么一种急救的办法，只要他没有明显的外伤的时候，马上解小便给他喝，喝了以后常常会很快苏醒过来。前一段时间也有一个报道：美国有一个儿童患了重症的腹泻，终于不治，就是说西医用尽了办法，治不了。最后他的主治医生采取了一个办法，用他母亲的大便输入到这个孩子的肠道里边去，这是最后的办法了。最后的结果并不重要，但这说明现代医学在研究过程中也发现：人体的排泄物，在一些时候对人体有其它药物无法替代的亢奋作用。当然他这个理念上用这个大便，恐怕是要用他母亲的那些，按现代医学的说法是用她的菌群去修正她孩子里边的菌群，但是这种解释应该说是解释不通的。因为你横不能把他母亲全肚子大便全弄到孩子体内去吧？实际上还是用了他母亲消化道里边的某些可以干预孩子人体某些信息、某些基因之类的携带这一信息的物质。这些很值得现代医学去研究。

后面的附注“服汤•脉暴出者死•微续者生”，《宋本》把它篡入了正文了，对后世的影响很大。我们今天把它还原为注解内容再来解读，则与历代注家的理解都大不相同。这是另一个作者写的注解，“服汤•脉暴出者死”，这实际是什么问题啊？这实际就是这个作者误用本方的一个经验教训。原因就是历代的注家都把这个少阴病视为心肾

经这一类的疾病，所以这个注解内容的作者必定是在没有表证的情况下，对那种阴性重证误用了这个方子，发生了医疗事故，把人给治死了。为什么“脉暴出”啊？就是因为有解表剂在里边，再加上一亢奋，一下把人体仅剩的一点能量都给折腾出来了。“微续者生”，很自然这就是他把这个方剂用对了，这个方与证相应的时候而应该有的效验的一种。

下边白通加猪胆汁汤证的病理：是阴性里虚寒证合并表虚证。

下边做个小结：少阴病症状表现为下利、脉微，以白通汤治疗后，不但下利未止，反而出现厥逆无脉、干呕、烦的，为白通加猪胆汁汤的主治之证。

咱们看看这个方剂：

白通加猪胆汁汤由五味药组成：葱白、干姜、附子、人尿和猪胆汁。关于这个方剂的药物作用什么的，我们前边都讨论了，咱们就不再去重复了，前边我们讨论的就等于说是方解了。

白通加猪胆汁汤方证临床统计的方证：

症状：厥逆、发热、烦躁、面色无华、呕吐、面赤、泄泻、口渴。

舌质：红舌、淡舌、紫舌。

舌苔：白苔、腻苔、黑苔。

脉象：细脉、沉脉、弦脉、数脉、弱脉、微脉。

现代应用有：消化不良伴脱水、咽炎、肺源性心脏病、肠伤寒、泄泻、急慢性胃肠炎、痢疾、霍乱、小儿泄泻、咽痛。

少阴病、二三日不已、至四五日、腹痛小便不利、四肢沉重疼痛、自下利、自下利者·此为有水气也·其人或咳、或小便利、或下利、或呕者、玄武汤主之①、②（316）

注：

1. 《康平本》“武汤主之”四字转行后变为顶格排版，前文均为降一字格，当为笔误。

2. 《宋本》此条文如下：

少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气，其人或咳，或小便利，或下利，或呕者，真武汤主之。

茯苓三两 芍药三两 白术二两 生姜三两切 附子一枚

炮去皮破八片

右五味、以水八升、煮取三升、去滓、温服七合、日三服、

若咳者、加五味子半升、细辛一两、干姜一两、若小便利者，去茯苓、若下利者、去芍药、加干姜二两、若呕者、去附子、加生姜、足前为半斤、

胡希恕：这个“或下利”呀，不对，啊。因为他头前儿有个“自下利”，还“或下利”，这个语意重复，不对头。应该“或不下利”，这个“下利”呀，上头应该有个“不”字，这与这文意呀，他才…他才相符。那么这一段呢，这就是说“里有停水，小便不利”。小便不利，啊，那么在这个太阳也好，少阴也好，他表不解。二三日不已者，那么二三天，那个以前，是要麻黄附子甘草汤微发汗的，以二三日无里证嘛，故微发汗也。他搁个“不已”，就是虽然服了麻黄附子甘草汤，而病不已。为什么不已呢？由于，他根本这个就由于小便不利，内有停水，你不兼去水呀，表不解。所以他这个书啊，前后他有些这个病理的关系呀，前后是一致的，没有说这一块儿这么讲，那一块儿那么讲的。咱们讲那个太阳病里头，啊，所以与“服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满，微痛，小便不利者”，跟这个是一样。那个就因为小便不利，那么他表不解，就像无汗的这个表证似的。而这个心下满微痛呢？他这个…啊，他这个水不往下行，往上撞。就像里有所实似的，所以你发汗呐，下之，都不能解，你非利

小便不可，啊。他用桂枝汤去芍药加茯苓白术就好了这一段也是这样子，二三日之所以不已，就由于小便不利，里头有水气。这个少阴病要是小便不利，里头有水气呀，一到四五天传里，非下利不可。所以到四五天，啊，传里了，“腹痛，四肢沉重疼痛，自下利”，那他由于小便不利，到四五日，你看看，四肢沉重疼痛，他这个表还不解。不过他这不解，里头有湿了，啊。“四肢沉重”，他不光疼。他这个…啊，郁于这个表的这个水分都存在呢，里头也有水了，所以，而且不能收持，他自下利了，转到太阴病。这就变成少阴、太阴的并病的。可是主要由于里头停水，那么这就说明了二三日所以不已，四五天所以四肢沉重、疼痛、自下利，一个原因就是由于小便不利，内有停水。所以他肯定下一个结论，“此为有水气”。都是这一个，这是一个主要原因。“其人或咳”，啊，这种水气呀，啊，表也没解，涉及于肺，他也或者“咳”；或者，啊，也兴小便利，啊，他头前儿不有个小便不利吗？或者也小便利，或者不下利，他小便利他就不下利，小便不利是水走了，水走肠间了，啊。这一个应该是“不下利”，不是要“或下利”了。那么或者自里水上犯而呕，无论这个或然以下的证候的有无，只是有以上“小便不利，四肢沉重疼痛，腹痛自下利”，只要有这一个，就可以用真武汤。这一个书啊，你们从头前儿你们看，凡是有或然的他都给弄一个加味的方子，这个方子绝不是张仲景的，因为什么？有些是很不合理。这是后人所附。他这个说是什么方主之啊，他冲着这个主证说的，这客证有无，你把水气去了，都能好的，去水气以解表嘛，表也解了，水气也去了。这个真武汤，啊，它也是个附子剂了，因为陷于阴证了，这是少阴病啊。太阳病只是用这个一般的利尿药就行。这一个利尿之中要加附子的。所以他也用茯苓、术，啊，加生姜他是治呕了，加芍药治腹痛嘛。那么这一个水气，啊，那么这是…这是在胃，啊，冲逆于上，或者呕，或者他下利，啊，而腹痛，那么它都治，但是陷于阴证，不加附子是不行的，所以他加附子。这

个方子都最常有了，啊，这真武汤经常用。“右五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服”。底下这个，啊，“若咳者，加五味半升”这东西都要不得了，啊。他是根据小青龙汤那一套，啊，加五味、细辛、干姜，啊。其实这不对，啊。“若小便利者，去茯苓”，啊。“若下利者，去芍药”，去芍药也不对呀，这个芍药这个药啊，它是个…啊，虽然它不是个酸收敛药，但是它起收敛作用这个药，你们看看这个大泻下药啊，都不用芍药，腹痛也不用芍药，啊，这个…这个…这个，啊，你像那个承气汤里头都没芍药，它起收敛作用啊。可是下利药里头呢，他用芍药，他治…他治腹痛，因为建中汤里他也用芍药，是吧？这阴证哪有去附子的，这得瞎说。这一个，所以他这个，啊，这个去加方法，要不得。我在这个…我以前教这个东西的时候，讲义里头，我都给去了。

李冠杰：这个条文在《康平本》是降一字格排版的条文。

其中在《康平本》，这个条文最后的“玄武汤主之”，“武汤主之”这四个字，另起一行的时候，抄成顶格排版的了，这肯定是笔误。那么在《宋本》，因为要把旁注的内容窜入到正文里边去，这里边的内容上就有所重复。所以，他把正文当中的“自下利”用旁注的“自下利者”给代替了。大家知道有这么一回事就行了。

解读一下：

“少阴病”，应该理解为初得病的时候，主要表现为少阴病的症状反应。但是，不是单纯的少阴病，同时还存在停饮的问题。

“二三日不已，至四五日”，这儿的“二三日不已”，就含有已经经过治疗而不得愈的意思。这个“不已”，如果未经治疗的话，古人一般不太用这个字。治了以后不愈的话，一般才这么论述。那么，“至四五日”，治了两三天没治好，迁延数日。迁延数日之后，病情加重了。

然后“腹痛”，“腹痛”是有多方面的原因造成的，既有寒饮的

因素又有胃肠功能虚弱的因素，同时还有血虚痉挛的因素。

“小便不利，四肢沉重疼痛，自下利”，都属于体液代谢不良的症状反应。其中“小便不利”既是症状又是病因。“四肢沉重疼痛”，这是人体肢体停饮严重造成的。因为大量的废水停滞在肢体部位造成组织失养，就会有沉重感。这还不仅仅是一个失养的问题，组织肌肉里边含的水分量过大，影响新水供应，造成组织失养。本身肌肉组织的功能就不正常了；另外一个就是肌肉里边含水量多，重量也会增加，也会感觉到重。在经方理论里边，常用“肢体沉重”这一类的症状来说明停饮。同时，这个废水，携带了很多人体的代谢物，也就是毒素。由于这些代谢物的刺激，还会造成肢体的“疼痛”。那么“自下利”，自下利，有两个方面的原因：一个是因为消化道内水份过多造成，也就是所谓的“水走肠间”了；第二个，是因为人体机能沉衰而致胃肠功能低下所致。这个病理因素在临床统计数据当中，真武汤证的“下利”，有将近一半的患者表现为五更泻。这就足以说明：主要的因素还是人体机能沉衰造成的。

以上的这些述症就清楚地表明：停饮是一个主要和关键的病理因素。这跟阳性的表证同时存在停饮的话，则不能用单纯解表的方法来治疗是同一个道理。这一条论述的就是这一类的情况。

凡是人体发生体液代谢不良的水证的时候，都有一个比较明显的特点：就是他的症状反应都比其他的方证要复杂一些。从机理上说，跟水份在人体的作用和特有的代谢过程有关。水份进入人体之后，通过消化道吸收以后进入血液，随着血液输布到全身各个部位，以供组织细胞营养。而在组织消耗这些水分的过程当中，必然就会产生一些废水（含有代谢产物的水分）。这一些废水，最后还要回到静脉里边，随着血液的循环，最终通过小便也好，汗液也好，甚至呼吸也好，最终排出体外。这个水分的代谢过程还有一个特点，就是人体各个部位的组织器官的状态不同，对体液代谢的程度也不完全一样。这个体液

在总体代谢不良的情况下，在某一个部位，或者是某一个组织器官尤为严重。那么在这种情况下，在不同的人体上，他停饮的部位就不同。也就是病理因素是一样的，但是，最后表现出来的症状是不一样的。所以凡是水证，临床表现都比较复杂。我们能看得到、摸得到的，手上如果说有停饮，轻的，往往是睡醒了觉后，两个手发胀；如果停饮重了，也会出现浮肿，常见的是下肢的浮肿。另外，舌质上的齿痕，也是停饮的一个铁证。齿痕是什么？舌体浮肿。有的是上眼皮浮肿，有的是整个面部浮肿，什么样的情况都有。

常常，两个人表现在不同部位的浮肿，有可能是一个方证造成的。就是因为有这样的情况存在，这个条文论述了好多的或然证。

接下来是“其人或咳”，凡是呼吸系统发生停饮的，会致使肺部功能直接受到影响，而发生或咳或喘之类的症状。如果腹腔以内的停饮比较重的时候，会上迫影响到肺，加重这一类的症状。有的小青龙汤证的病人，在医院里面，有的能够查出来，比如支气管炎，甚至肺炎这一类的都有可能。但是有的病人在医院里面一点病也查不出来，但是他咳嗽，也气短。这一类的病人，常常有一个特征，就是每当他躺下的时候，他的症状就会加重。实际上这是他腹腔里边停饮重，整个胃肠所占的空间就会变大，平躺以后，会往上挤压横膈膜，肺的呼吸空间就变小了，肺就失去常态，他也会咳嗽。这个时候用现代的科学手段是找不到他的病因何在。往往就当感冒治。

我就碰到这样的病人，是个老太太，输了七天的液，以前的时候，只要一咳嗽，她就去输液，输上七天液，差不多四、五天，七、八天就好了。这次输了七天不管用，又输了七天，后来不敢输了。因为她的女婿就是医院里边的主治大夫，他可知道抗生素的副作用相当重。后来给她吃小青龙汤就好了。

“或小便利”，这儿的“小便利”，应该理解为小便频数。人体出现停饮之后，常会表现为小便不利，小便量少、次数也少。但是有

时候，也会表现为小便的次数增多，但是量并不多。这也同样是停饮，常常是停饮证一个很重要的症状。而且这类的症状，常常会发生在那些泌尿系统机能偏于低下的人体身上。

“或下利”，原文可能有错误。胡老说的：这应该是个“或不下利”。因为在前文当中有“自下利”，再来一个“或下利”就没有意义了，这个地方很可能有缺字的情况。

这个地方跟大家交待一个问题，在《康平本》叫做玄武汤，到了《宋本》呢，叫做真武汤，这是一个方剂，名字不一样。

那么在临床当中，这个真武汤证，虽然可能出现“下利”的症状，但是更多的则是表现为“不下利”。医案统计 400 多个医案，有下利一症的，只有 55 例，出现的几率并不高。

“或呕”，这个呕呢，是胃中停饮的一种反应。实际上，真武汤证的患者在小便不利的同时，最难受的感觉是胃中不舒服。我碰到过好几个这样的病人，吃了真武汤以后，而且是小剂量的真武汤，他感觉非常舒服，很快就好了。

在实际临床当中，真武汤证的症状反应还要复杂得多。当时古人的写作条件有限，已经有主证，也有或然证，把真武汤证的特征已经论述得比较到位了。你只要能够准确地把握这个方证的病理特征，在临床当中，自然就会举一反三、融汇贯通。

真武汤证的病理：阴性的偏于里虚寒、又有停饮。只要符合这种条件，停饮证又比较突出的，用真武汤的机会就相当多。

条文的旁注：“自下利者，此为有水气也”。是对这个条文的述症，所做的病理解释。这个解释还是比较贴题的，对于我们理解条文，有一定的帮助。

关于真武汤的方证和现代应用，在第 82 条的学习当中，已经做过比较详细地讨论了，这里就不再重复了。但是水证临床症状反应比较复杂。那么这儿，把方证的症状再强调一下：食少纳呆、浮肿、咳

喘、腰膝酸软、肢冷、形寒、头目眩晕、小便不利、神倦、心悸、腹胀、呕恶（呕吐恶心）、面色白、身瞤动、便溏、下利、腹痛、胸闷、痰白量多窒息。这些症状的范围比较宽。而且，症状出现的几率差别不是特别的悬殊。

在方后注解后面，有一些加减的内容，这个都不是经方的内容，都是后人所加的，大家知道这么一回事儿就行了。

少阴病、下利清谷、里寒外热、手足厥逆、脉微欲绝、身反不恶寒、其人面色赤、或腹痛、或干呕、或咽痛、或利止、脉不出者、通脉回逆汤主之、（317）

甘草二两炙 附子大者一枚生用去皮破八片 干姜三两强人可四两
右三味、以水三升、煮取一升二合、去滓、分温再服、
其脉即出者愈、面色赤者、加葱九茎、腹中痛者、去葱、
加芍药二两、呕者、加生姜二两、咽痛者、去芍药、加桔梗一两、利止脉不出者、去桔梗、加人参二两、（注）脉病皆与方相应者乃服之①·

注：“脉病皆与方相应者乃服之”《宋本》作“病皆与方相应者乃服之”。

胡希恕：“少阴病、下利清谷”，啊，这就所说这个少阴病，啊，传里转属太阴了，这里虚寒之极了，啊，食谷不化，下利清谷。他说这“里寒外热”者，指得下边证候说的。“下利清谷，手足厥逆”这是里寒；“身反不恶寒，其人面色赤”这是外热。它指着这一个，指着证候说的，据证上他是论的，啊。那么这个少阴病，啊，这里头虚寒之极呀，所以他下利清谷，而手足厥逆。这个病啊，常常有这个情形，真正到这个危重的时候啊，他这一点这一点浮阳啊，都现于外了，那里面是一片沉寒呐，这个病最重了。那么他应该，这个人应该，啊，

恶寒呐，他反不恶寒；那么面色也不应该…应该赤啊，他反而面色赤。这一个面色赤不是这一个，咱们头前儿说表不解、不得小汗出那个浮阳在面了，这是真正虚候。内里头极寒呐，它把这点儿，人身上这一点这个，啊，热量都弄到外头来了。所以这一个要虚脱之象啊。那么也有些客证出现，啊。他下利嘛，或者是这个寒刺激这个，啊，肠子，肚子也痛；或者里头的水，不光下利，还往上逆，他就干呕，啊；也有的时候，啊，由于这个下利伤阴太重，啊，咽干，也可以咽痛。“或利止脉不出者”，啊，这个利止脉不出，就是无可再下了，没有脉了，脉不出。那么这就是一个“虚脱之象”了，啊。这只能用通脉四逆汤。所以叫通脉四逆呢，啊，脉没有了，能使它复通。所以我们头前儿那一个就是应该用通脉四逆加猪胆汁。我们看看这个通脉四逆，就是四逆汤，也是甘草、附子、干姜，但是附子干姜都加大用量啊。附子也是用一个大的，这附子大小之分可，那可相差很多很多的。我问过他们药房，这个附子大的有一两的，啊，甚至一两多的；那与一般那个小附子那差称得多；这个干姜搁三两。你们看看那个白通汤，干姜才一两哦，啊，差太多了，啊；而且呢，他这个是分温再服的，匀二剂。匀两剂呢，干姜这个这个药啊，要是三两的话应该是 9 钱，一剂呢，应该 4.5 钱，这很重了。要是强人，他底下还注了，还要加干姜，搁四两。那四两更多了，那就是一副药里头就是 6 钱了，现在咱们以克论就 18 克了，啊。所以这一个通脉四逆汤啊，它就是在四逆汤这个基础上而增量附子、干姜，啊，温中祛寒。而且这一个，附子这个药啊，附子、干姜都有这个作用啊，它起个亢奋作用。这个机能沉衰了，啊，像咱们说这个虚脱，啊，虚脱，以致于脱…啊，这个心…心力衰竭，它都能振起这个机能的。你看看他这个书里头，到这个时候面没有搁人参的。人参这个药也是个亢奋药，也是个补药嘛。可是它微寒，这个…这个人参。真正到这个沉寒客冷，到这个阴虚之候，人参用不得。那么咱们现在还是…最迷信这个独参汤，遇着这个时候了，

就独参汤就来了，来一个死一个，这我见着多了。那只能用，用这个通脉四逆这个法子。轻一点的，也得用四逆汤。这个将其咱们讲到霍乱，霍乱病里头啊，这个例子多的很。他底下也有些或然证候，他也给用些加减方。这个加减方啊，一点没有道理了。这个时候你还加葱9茎，那…要是脉微欲绝，啊，或者脉不出，你再发汗，那还不速其死吗？所以他这个加减，加减的这个，一点也没道理。这个你们好好，啊，自己看一看就知道了。

李冠杰：这条文在《康平本》是顶格排版的条文。

解读一下：

“少阴病”，在这里应该理解为通脉四逆汤证可由少阴病发展而来。从临床统计资料看通脉四逆汤证的医案，确实有一些就是因为感冒发展为严重的里虚寒证的。但对于条文中的述症，我们应该区别不同的情况来认识。咱们把症状分一分，因为条文里述症比较详细。

“下利清谷、手足厥逆、脉微欲绝”，这三个症状都是阴性里虚寒证典型的症状反应，实际上也是通脉四逆汤证主要的症状反应。通脉四逆汤就是四逆汤加重了干姜和附子的用量，所以它的适应证的基础就是四逆汤证的重症。这三个症状在四逆汤证里也是常见的症状，如果讲主证副证，应该把它看做是通脉四逆汤证的主证。

“里寒外热、身反不恶寒、其人面色赤”。“里寒外热”可以理解成一半说病理，一半说症状。“外热”指的是体温高，病理上有一些热象也可以称之为“外热”，但这种外热不代表疾病的本质。这三个症状是通脉四逆汤证中一些特殊的症状反应，特殊并不一定是出现频率很低，特殊就在把通脉四逆汤和四逆汤相比较，通脉四逆汤出现这类情况的几率比较高，所以在通脉四逆汤证中论述得比较详细、全面。

一般情况下，阴性的里虚寒证常会以“畏寒肢冷”为主。但是当人体机能衰弱到一定程度的时候，有可能会出现一些反常的现象。这

实际上是人体在抗御疾病的过程中，表现出来的一种生理上失去常态的情况，或者说是人体生理功能的一种乱象。

“里寒外热”，是中医常称之为“真寒假热”的一种病理状态。在四逆汤证中也会出现这类情况，比如后边的第 389 条四逆汤证的条文中，也有类似于“身反不恶寒、其人面色赤”这类的症状反应。

接下来的症状是这个方证中容易出现的一些或然证，这个或然证是因为人体机能特别沉衰时容易出现的一些特殊的症状，它的机理和真武汤证、四逆散证出现的或然证不完全一样。

“或腹痛、或干呕”这都是里虚寒比较严重常会出现的症状反应。

“或咽痛”是这个方证一个比较特殊的或然证，从实际临床应用看，“咽痛”出现的几率处于中等水平，几率算比较高了。因为“咽痛”和“畏寒肢冷”那类症状不一样，这么重的里虚寒证何来“咽痛”？目前真能比较让人信服的解释还不多，我们就把它当做一个经验：当人体陷于里虚寒证比较重时，有时候还会出现“咽痛”这类情况。

“或利止、脉不出者”，这作为一对相互关联的症状反应，因为有“脉不出”可以佐证“利止”，不是病向自愈的方向发展的证候，而是因为此前“下利”过于猛暴，使人体消化道内已经无物可下的一种证候。这个情况就已经接近第 390 条里论述的通脉四逆加猪胆汁汤证的程度，但是通脉四逆汤证还达不到那种“汗出而厥、四肢拘急不解”比较危急的状态。

通脉四逆汤证实际上就是四逆汤证的一种重症。因为人体的机能沉衰得严重，所以有时候会出现一些反常的症状，比如把条文论述和实际临床统计集中到一起来看，临床中会见到“目赤”。一般像眼睛发红这类的都认为是热证所致，但是当人体真正寒到一定程度时也可能出现，它另有原因；像“咽痛”、“反不恶寒”，或者“面色赤”这类的，中医叫“格阳”。从这儿可以看出，这时的人体确实存在一定的热象，特别是“反不恶寒”，但是这种反常的症状反应，实

际上是在人体内环境严重失衡的状态下表现出来的一种错乱状态，它并不代表疾病的本质，也不是主要矛盾。

通脉四逆汤证的病理：是典型的阴性里虚寒证。

通脉四逆汤的组成：甘草、附子、干姜，附子和干姜的量比较大一些。方药的组成和四逆汤完全一样，只是干姜和附子加了量，所以它的适应证就是四逆汤的重证。因为方证条文里有或然证的论述，所以在方后也有一些加减，和其它的加减一样都不是经方理论上的东西。

从另一个角度，如果把里虚寒证整体看一下，会发现从理中汤、理中丸，到四逆汤、通脉四逆汤，再到通脉四逆加猪胆汁汤证，它是一个由轻到重，直到危重、危象。把这些方证联系起来，就形成了针对所有不同程度里虚寒证的一个完整治疗体系。吴茱萸汤证也属于里虚寒证，但它是另一条线，是因为里虚寒胃中停饮为主。我们通过四逆汤和通脉四逆汤的差异，能看出用通脉四逆汤完全可以代替四逆汤。为什么分这么细？实际上说明古人在这方面已经到了细致入微的程度了，经方对于人体的各类疾病真是到了非常细致、全面的程度。在经方里有很多这类的方剂，比如小承气汤至少有三个方子药味都是一样的，就是比例不同，它所针对的状态就不同。虽然方子本身没有发生多大质的变化，但它对的疾病状态却有了一定的变化。这说明古人通过多少年多少代的临床实践，已经总结得非常全面、非常得细了。

看胡老的临床实践能证明了，他自己也说我没感觉有经方治不了的病，实际上这走出了用经方来治疗所有疾病的一条路。这条路古人早就走过了，但是后来因为医学理论出现了方向上的偏差，致使咱们偏离了方向，没沿着这条路好好地走下来。如果一直都用经方治病的话，那么中医绝对不会是现在这个状态。

通脉四逆汤证在临床表现上，它的症状反应要跟真武汤证相比差很多了。它主要的症状反应：四肢厥逆、下利清谷、面红目赤、腹痛、

咽痛、口干不欲饮、身热、消瘦、头汗出，就统计了这么多症状。

舌质：淡白、胖嫩、红、淡紫。

舌苔：厚腻苔、薄白苔、薄黄苔、少苔、无苔。

脉象：沉脉、微脉、迟脉、细脉、紧脉、虚脉。

用通脉四逆汤治疗机会的现代疾病有：急慢性胃肠炎、肠出血、痢疾、霍乱、腓肠肌痉挛、急慢性呼吸衰竭、休克、心力衰竭、急慢性肾功能衰竭、尿毒症、风湿性肌痛及关节炎、急性传染病高热后期、肠伤寒后期并发出血症、感冒、咽痛。

少阴病、四逆·其人或咳、或悸、或小便不利、或腹中痛、或泄利下重者、回逆散^①主之、（318）

注：“回逆散”《宋本》作“四逆散”

甘草^炙 枳实^{破水渍炙干} 柴胡 芍药

右四味、各等分^①、捣筛、白饮和、服方寸匕、日三服、

注：“各等分”《宋本》作“各十分”。

咳者、加五味子、干姜各五分、并主下利、悸者、加桂枝五分、小便不利者、加茯苓五分、腹中痛者、加附子一枚、炮令折^①、泄利下重者、先以水五升、煮薤白三茎^②、煮取三升、去滓、以散三方寸匕、内汤中、煮取一升半、分温再服、

注：

1. “炮令折”《宋本》作“炮令拆”。

2. “煮薤白三茎”《宋本》作“煮薤白三升”。

胡希恕：这一个不是少阴病，这一个根本就是少阳病。由于这个气的闭塞，啊，而发生四逆，就是心下部位，这个柴胡啊，它祛胸胁苦满的。胸胁苦满心下再闭塞，啊，阻碍人的这个气血，他也现四逆，

但是很少。那么这一个方剂呢，它祛热，啊，它柴胡为主啊，治少阳，它不治寒。不应该搁到三阴篇里头，搁到少阴篇里头还是不行，啊。那么这一个，总是古人就这个外观呐，看他四肢厥逆这一种情形，也就…因为他也有时候腹中痛，也有治下利的作用，认为这一种腹痛下利，这少阴病转属太阴，他这么看法。其实不是的。他这个下利是个热利，啊，不是寒利。那么这个少阴…这个四逆散我常用，这个方子最常用了。凡是大柴胡汤证，咱们大柴胡汤证心下急嘛，啊，郁郁微烦嘛。这一个，这一个方剂也有心下急、郁郁微烦。但是他不呕，你看它没有半夏、生姜，没有。没有大黄，不可下，你就用它就没错的。其它都像大柴胡汤证。而且这一个方剂呀，很少有四逆，啊。很少，因为有这个枳实啊，这个气闭塞的厉害，或者有，但是不一定有的，啊。所以他这个四逆呀，在临床上很少见。虽然它名为四逆散，但是他这个四逆也很少见，不是多见。那么由于这个气不得下行，啊，这个，这个枳实它还是疏气的药了，而上，啊，上逆于肺，它也有时候治咳。凡是柴胡剂大概都治咳。柴胡剂这个药啊，它是胸…它是疏理胸膈这一，这一带。啊。“或者悸”，悸指着心下悸，啊。“或小便利”，啊，因为枳实这个药，枳实、厚朴这一药，他不祛饮消胀嘛。也都祛水、祛湿，那么小便不利呢？行气也利水。“或者腹中痛”，这一个药它根本就有芍药甘草汤了，啊，枳实芍药汤两个合起来的。枳实芍药汤它是行气缓腹痛，啊。这个《金匮要略》里头有，腹满腹痛，啊，芍药甘草汤、枳实芍药散全治的。在这个妇科里就有，啊。这个女同志产后，这个腹中痛，那么一般呢？要是没有瘀血，大概都是用枳实芍药散，就…就好的。行气，啊，它也有，啊，止痛。所以他这个药，也治腹中痛，根本就治，不用加味。“或泄利下重者”，啊，有这个，啊，芍药甘草汤，芍药甘草汤就治下肚子，就治下利呀，芍药甘草汤这两味药啊。那么如果再有热，啊，柴胡清热，所以这也是治热利嘛，热利，啊，心下闭塞而有下利的，这一个方子也治的，

所以这个方子有治下利的机会。所以这个或…啊，虽然它是一个或然兼证，但是这一个呀，我们都拿当个主证观可以的，用这一个方子。假设说有柴胡证，那么有这些问题，可以用的。尤其这个腹中痛，啊，或者下利的情况。这一个跟我在一块儿看病的人大概都知道，我们治肝病啊，有大便不好的，我常用四逆散，四逆散合用当归芍药散，啊，那么肝区痛的厉害呢，加点儿郁金、香附啊，这个我在这个临床上常这么用，从哪来的呢？就根据这一条。就是“下利腹痛”。所以我们在慢性肝病里头，就治肝炎呐，啊，我们不能不用柴胡，因为它疏理肝嘛，是吧？但是他要是下利，你用柴胡桂姜汤就不行，柴胡桂姜汤这一个，它治大便干，你用这个倒是蛮好的，啊。就是这个方子合用当归芍…当归芍药散加减。肝功能不好呢，你可以加丹参、茵陈，啊。所以这一个，我就根据这个方子。总而言之，你这个，用这个方子，你得熟。你到时候啊，啊，合用啊，你是拆，还是化拆呀，心里就明白一些，是吧？它不呕嘛，你就不要搁半夏了，他要呕呢，那就是你大柴胡汤里把这大黄去了就行了，那我也常，也用过，是吧？他底下这些，这些加减更要不得了，啊。

李冠杰：“少阴病”后面的“四逆”是个旁注。这个地方跟四逆汤一样，所有的《康平本》里边，四逆汤都用“回”字，回逆汤。这个在《宋本》里是四逆散，在《康平本》里是回逆散，但是这个“回”跟“四”你要品味，它有一定的差别。咱们后面会给大家再进一步讨论。这是个顶格排版的条文。

下面，我们解读一下：

因为四逆散方证，它不是阴性表证，所以这个“少阴病”，只能理解成有近似于少阴病的某些症状反应，或者是这个方证可能由少阴病发展而来，就只能这么来理解。

旁注“四逆”，指的四肢逆冷，它在《康平本》是一个旁注内容，意味着这个条文的正文，它的述症全部是后面的或然证。虽然说在某

些医案里面，这个方证有出现四肢冷的记录，但是从整体统计数据来看，这个症状在这个方证当中出现的几率很低。这个方子还有一个特点，临床当中单独用的，非常少，所以说这儿还可能有别的因素存在。如果这个方证当中有四肢冷这一类的症状的话，实际上这也是半表半里证的一个症状反应。小柴胡汤证当中，有时候就可能会出现四肢冷、四肢发凉这一类的症状，但是出现的频率一样也不高。半表半里证属于浅表性疾病和里证之间的一种疾病状态，所以说它的症状反应相对地说比较复杂一些。这个旁注内容，可以理解成对本条文述症的一个补充，但是要把它理解成补充，不能把它当主证来看。可以把它前面加上一个“或”字，挤在正文里面也没有什么不可，也是一个或然证。

所以说这个条文压根就没有论述一个稳定的症状，我们看到《康平本》以后，对方后加减，也能起到一个非常好的正位作用，到后边我们还会详细说。我们再来看看这个四逆散，在《宋本》里边叫四逆散，在《康平本》里边它叫回逆散。既然是四逆这种症状，在这个方剂里出现的频率这么低，而且这一个症状还是后人加的一个旁注，不是原著里面内容，那么《宋本》为什么叫四逆汤？《康平本》为什么把它叫做“回逆散”？值得大家品味。这个“回”跟回逆汤的“回”，恐怕“回”的对象不一样。那个“回”真有，因为回逆汤常常会表现为四肢厥冷，所以叫它“回逆”，是指的它有恢复四肢厥冷的这个功能。这么理解比较切合实际。这个“四逆散”也完全可以这么理解，把它理解成“回逆散”的话，它“回”什么“逆”呀？它一大堆的或然证，就因为它的症状不稳定，这不是人体发生了错乱，或者说某种程度上可以把它称作逆转，有这方面的意味。至于方剂叫什么名字，本身不是特别重要，跟方剂的应用和治疗也没有什么关系，只是我们去体悟一下。

四逆散方在柴胡剂里边，它是一个比较小的方剂，用药也比较简单。但是从药物组成看，它适用的病理当中，既包括了半表半里的虚

热证，也有血虚证，也有气证。它既有芍药甘草汤，又包括了枳实芍药散，还有近乎于半个大柴胡汤。所以说这个方证的适应证，反而是半表半里证当中临床表现较为复杂的一个方证。恐怕也正因为这个，条文里没有论述所谓的主证，而全是或然证。

“其人或咳”，就咳嗽了。这是半表半里证的一个常见的症状，在柴胡证当中这是一个比较常见的。

“或悸”，指的是心悸而言。在临床中，这个方子有治疗像冠心病之类的疾病的机会。而且临床体悟，这个方证当中的心悸，多是由于心脏部位状态不良，或者是由心理因素造成的。

“小便不利”，在这个方证当中出现的频率还比较高。因为这个方剂当中，没有专门治疗体液代谢不良的药物，“小便不利”应该是在这个方剂的适应证的病理状态下，对人体泌尿系统产生了影响所造成的。

“或腹痛”，可以视为这个方证的一个主要的症状反应。但是为什么没把它放到前面，如少阴病，腹痛，或……，这个“腹痛”表现得非常复杂，有的人表现为单纯的胃疼，有的人表现为少腹痛，有的人还会表现胸胁痛，还有的表现为腹直肌紧张、痉挛，痉挛痛，甚至还有的人表现为腹部的窜痛，一会儿这儿痛，一会儿又到别的地方痛了，痛无定处，这种现象就反映了这个方证本身就比较复杂，有这样的特点。

“或泄利下重” 这个症状实际出现的机会也不多，但是确实有治疗这一类症状的纪录。如果说在这个方证当中出现下利的话，那么这种下利也是一种热利，因为这个方剂总体偏于寒。

这个方子在临床中是一个常用的方子。关于这个方剂的应用，我们在座的很多人都学过胡老讲课的内容，胡老关于四逆散有一个非常精辟的论述。他说凡大柴胡汤证不可下者，多适用于本方，说得非常得简，也非常的要紧。这一点大家临床当中去体悟，当你四诊的过程

当中，你辨来辨去，发现他似乎是一个大柴胡汤证，但是没有大便不通，他没有那么重的里实，这种情况下，用这个方剂的机会就比较多。我自己在临床当中体悟，这一类的病人，他有时候腹诊表现为这个大柴胡汤证，心下按之满痛，好像四逆散也有这类的症状反应，你按胃的地方，里边有点满的感觉，或者说按的时候有点疼。

四逆散的病理：半表半里的虚热证里实证合并血虚证合并气实证。

四逆散由四味药组成：甘草、枳实、柴胡、芍药。这四味药是各等份的，做成散服。这个方子虽然小，但是里边包括了芍药甘草汤、枳实芍药散。它适应证是一个较为宽泛的症状反应群，从临床统计资料看，也能清楚得反映出来。临床应用真正单独使用四逆散治病的这种医案非常少。或者是合方的，或者是加味的，非常多。多到什么程度呢？咱这有个数据啊，四逆散证临床统计的资料一共是 414 个医案。用药当中有加味的 251 味，就说统计到的 414 例当中，他们加过的药味重复的，（不重复的计算一下有 251 味），一共有 1664 味次。可见这个加减之严重。

我们从一个症状来看，在这 400 多个医案当中，有 103 例是便秘，这个出现的几率就很高了。但是我想咱们学经方的人一说你就清楚，这个四逆散如果说出现便秘的话，大家看什么问题啊？实际上这相当一部分本身就是大柴胡汤证，但是那个医者大概用大柴胡汤不太熟，对四逆散掌握得比较熟，他就用四逆散加上了一些通便的药，等于说取代大柴胡汤了。要如果真正是大柴胡汤证的话，用这种方式治，自然疗效就会打折扣，不一定治不好，但是可能会吃比较长时间的药。

这个方剂后边的加减。在这个方证当中出现加减很容易说明问题。这里有一点可以让大家很清楚地看出这个方后加减就是后人加的。这个条文正文的述症当中都是或然证，按着方后加减的逻辑，凡是或然证就必须要进行加减，于是就出现了另一个逻辑上的问题。出

现了什么问题啊？既然这个条文当中全是或然证，那就没有主证的基础了。有了或然证就得加减，那么这个方剂治什么呀？你在什么基础上进行加减哪？大家想想是不是这么回事。这就充分证明了这个方后加减这些东西啊，这都不可取。

下面是四逆散方证。四逆散在临床当中出现的症状反应，出现频率最高的就是腹痛，依次是食欲不振（这个食欲不振我跟大家说一下，我在临床当中碰到过有一两个病例，食欲很好，吃了饭以后时间不长就胃疼，胃疼得受不了，但是他到吃饭时候还愿意吃。就用单纯的四逆散治好他，吃其他的什么方剂也没用。这说明这个方证反映出来的症状，常常不太稳定，不具有稳定性。所以没有一个是固定症状）、恶心呕吐、往来寒热、胸胁满、便秘、腹胀、小便不利、咳嗽气短、头晕、头痛、噎气、自汗、乳房痛、口渴、面色青暗、心悸、神昏抽搐、黄疸。

舌质：红舌、淡舌、淡胖舌、边有齿痕的舌、边有瘀点的舌。

舌苔：白苔、黄苔，主要就这么两项。这个白苔里边你看包括，薄白苔、白厚苔、白滑苔、白腻苔啊，但是呢基本上都是出现白象。

脉象：弦脉、数脉、细脉、沉脉。

有应用四逆散机会的现代病非常多，达到了 103 种病，就不一一地跟大家说了。我就拣了比较有代表性的：急慢性胃炎、肠炎、阑尾炎、胆囊炎、肝炎、胰腺炎、胃及十二指肠溃疡、肠粘连、胆道蛔虫、胆石症、肝硬化、浅表性胃炎、胃窦炎、胆汁返流性胃炎等消化系统一类的疾病。

还有神经官能症、脑萎缩、神经性头痛、癫痫、肋间神经痛，跟神经系统有关的一些疾病。

跟循环系统有关的，病态窦房结综合征、心房纤颤、原发性心肌炎、冠心病、早搏、心绞痛这一类的。

呼吸系统的，像支气管肺炎、支气管哮喘、气胸、肺结核。

这说到肺结核，可能跟大家说过几次了，也是我的一个老病号了，他二十多年的肺结核。这段时间他不怎么吃药了，好了。记得有一次他来我这儿就诊，他每次来除了感冒以外就是咳嗽得厉害了。这几天咳嗽又厉害了他就来了。他以前一直在吃小柴胡汤合上小陷胸汤，后来出过一次实证，用的是其中包括四逆散，还有厚朴三物汤，还有一个什么方剂来的。这次我感觉他就应该是一个偏于四逆散证，就给他三天四逆散，后来一直再没有回来，后来碰见他，我说这次药吃得怎么样？他说：吃了，吃完了就好了，吃下去就管用了。那就是单纯的用四逆散，他就是个肺结核。

妇科里边：盆腔炎、更年期综合症，经期紧张综合症、月经不调、白带多、痛经、乳房胀痛、乳房炎、子宫脱垂这一类的。在妇科病里面，这个方剂应用的机会很多。比如痛经，如果没有明显的虚寒证的话，常常就是当归芍药散证。当归芍药散证如果有气证，或者又有柴胡证的话，四逆散合上当归芍药散的机会就很多。而且四逆散合上当归芍药散以后，甚至有时候合上桂枝茯苓丸，比一些时方里边常见的治疗这一类的病的逍遥丸之类的，比它们疗效要好。当然不能这么用，要对证，一定要在临床当中对证，不要去套什么妇科病或者是哪一类，用哪一类合方比较好，这样就会形成一种定向的固化，千万不要把自己用药的这种方式给定住。在临床当中，现什么样的方证，你就用什么方子，而不要有框框。

泌尿系统：尿路结石、肾盂肾炎、肾周围炎、慢性肾炎、膀胱炎、前列腺炎，睾丸炎、附睾炎这一类的，包括阳痿，这个胡老提过，其他医案也有。胡老的经验是加龙骨牡蛎。这个我也用过，有效果。

有一些像外伤一类的，也有用这个方子的机会，但像这个，估计大部分都是有加点别的药味的那种情况。比如像急性腰扭伤、胸胁腹壁挫伤这一类的病。

还有五官科的：中耳炎、结膜下出血、结膜炎、流行性出血热等

等。包括鼻窦炎、萎缩性鼻炎、三叉神经痛。就是说涵盖的病谱的范围就很宽泛。

这里边也有一个很实际的问题，因为在临床当中这个加减的幅度太大，所以说这些东西，我们仅作参考，不是说这么多病都用一个四逆散就能治了。

在整理这些资料的时候，我发现有一个资料上说了一些中医的证，或者是中医的病，比较有特点，虽然没有代表性，但是比较有特点。可以启发我们在临床当中拓宽应用四逆散的思路。你像筋结、臭汗、指尖灼热，这是一个很特殊的一个症状。大家不要小看这个，凡是这些特殊的，有特点的症状，常常可以作为用某些方子的一个可靠的依据。还有像胸闷、欠伸、乳溢鲜血、乳汁冰冷症（你看这个也是比较奇特的）、噎食、夜哭、牙痛、口香症（口香症也是一个比较不太常见）、痹症、不食症、不孕症、秋燥、鼓胀、小儿发热肢厥（发热反倒是肢体发冷）、小儿脱肛、疳积。

少阴病、下利六七日、咳而呕渴、心烦不得眠者、猪苓汤主之、（319）

猪苓^① 茯苓 阿胶 泽泻 滑石各一两

注：《宋本》此处有“去皮”二字。

右五味、以水四升、先煮四物、取二升、去滓、内阿胶、烊尽、温服七合、日三服、

胡希恕：这个更不是少阴病，啊，这一个根本就是没道理。“下利六七日，咳而呕、渴，心烦不得眠”，这个纯粹是，啊，水谷不别。水谷不别的这种自下利，起码得有小便不利……（音频 034 完）（音频 035 始）“下利，咳而呕、渴，心烦不得眠”用猪苓汤不行的。

他也不知怎么搞到少阴病上了。这我想这一个，这也是这一个…也兴是…这里头有错误，啊。这个猪苓汤我们最常用的方子。猪苓汤这个药与这个五苓散是不一样。五苓散有气上冲，五苓散呐，啊，它这个…常是表不解，他因为它在桂枝汤的基础上的。这个猪苓汤没有表不解的情形。所以搁到少阴篇里头一点意思没有。这个猪苓汤它是一个利尿消炎，就是利尿去热。所以我们是由于这个利尿有问题而有炎症的机转，大概用这个方子都好。你像咱们用这个，啊…泌尿系感染这一类的病，这咱们常用了，就用这个猪苓汤加生薏仁就行。那么，啊，热的较比厉害，小便特不利，也可以稍加大黄。这个大黄这个药啊，虽然我们从小便往下，啊，大小便往下行，它能诱导旁的这个炎症。你像咱们这一个，啊，你像这…在临床上都常用了，像肝炎吧，真正实证咱们也有…有用大黄的时候。它虽然往下泻，但是诱导其它的炎症，啊，消失。所以大黄这个药也是个好药。但是我们对这个泌尿系这一方面，不要重用，要少用，不能过一钱。那么最常用的呀，就是用这个猪苓散加生薏仁，这一个你在临床上可以试验，对于这一种，啊，泌尿系感染呐，我认为这个比西医，比咱们吃那个西药还快的很，啊。可以说百发百中。加上大黄呢，有的时候这个尿结石大概很好下，这个生薏仁不要忘了。

李冠杰：这个条文在《康平本》是顶格排版的条文。

解读一下：

因为这个条文，他的述症跟猪苓汤的实际临床应用出入比较大。所以，在这儿我们就只能从字面上，做一般性的理解。

“少阴病，下利六七日”，在这条条文当中应该视为是个病因，是指少阴病或者貌似少阴病的这种情况。患者又出现了下利一直迁延至六七天之后，发生了猪苓汤证。从猪苓汤方剂来看，这个时候即使有少阴病，也不是单纯的少阴病，而是同时伴有水证的这种情况。

“咳而呕渴”，这是三个症状：咳嗽、干呕或呕吐、口渴。这个

咳嗽在水证当中，是一个常见的症状反应，一般的就是呼吸系统，这一类的器官有停饮的情况所致。这个“呕”呢，应该是胃中停饮所致。那么“渴”呢，一方面跟五苓散证中的口渴有相同的病理因素，就是旧水不得出，新水吸收不好，造成组织缺水；另一方面，这个方证同时伴有里热，所以，还有一个热的因素。

“心烦不得眠”，就是因为有里热存在，而且，人虚造成的。那么里热本身，就可以造成人出现心烦不能睡眠的这类症状。再加上条文里边论述的，又有六七天以上的病史。所以这个人体已经比较虚了，所以这个地方应该是一个虚热证。

上边这个分析，只是条文的字面的意思。再结合猪苓汤的方药，我们做出的一些分析和理解。但是实际临床统计资料当中，这个方证论述的这些症状，出现的几率都非常低。在统计到的 119 个医案中，只有 18 例有失眠的纪录。这个条文里的其他症状，基本上都没有出现的几率。

所以对于这个条文里边的述症，我们只能这么理解：就是少阴病或者是近似于少阴病，同时伴有下利，经过数日以后，非得是在这种情况下，出现的猪苓汤证，才会表现为这样。这是猪苓汤证当中比较特殊的这么一种情况，我们现在只能这么理解。但是跟实际临床有一定的差距。我们客观地展开就可以。

那么猪苓汤证在临床当中统计到的资料，统计到的医案一共是 119 个，其中症状出现频率最高的是尿频及痛（尿频及疼痛）、红赤灼热 66 例，小便无力 35 例，血尿 27 例，腰痛 23 例，发热 23 例，浮肿 22 例，纳呆 19 例，失眠 18 例。这些症状是比较典型的。

关于这个方剂的其他资料，咱们在学习 223 条的时候已经进行讨论过了，在这就不重复了。

少阴病、得之二三日、口燥咽干者、急下之、宜大承气汤、①（320）

注：《宋本》此处有大承气汤方及方后注，此从略。

胡希恕：这个少阴病，它一般传里的时候传太阴。但是也有特殊情况，也有传阳明的。这个少阴病它根本就是，啊，津液虚呀，是吧？那么它要传阳明呢，它再一化热，那，那了不得。所以它这个津液枯竭和这个大便燥结都特别迅速，所以要有少阴病的外观，而发生阳明病，大概都要急下。他这一段就是，少阴病只是二三天的时间，那么开始他是在表了，他二三日之后他要传里，那么就突然间口燥咽干。咱们讲太阳病的时候，口燥咽干就不可发汗嘛，是吧？那就是说是里头，啊，有热盛津液虚衰的一种反应了，所以急下之。那么这一个要稍一…啊，延误啊，这个津液有枯竭危险。咱们讲阳明病也讲了，阳明病本来没有死证，假设津液虚竭之后这个情形，那你是这个攻补两难了，正虚而邪实。你攻邪吧，这个人受不了；你扶正吧，哎，这个邪在那儿搁着呢，越补越实。所以这个阳明病这个死啊，全是，啊，热实津液虚竭。这个少阴病一…这个来头，一来就有这种情况，所以没有其他的情况呢，他就…开始就是口燥咽干呐，所以这不可轻视，啊。若不急下，转过来他就是一个，啊，那就是这个…内里头实得厉害，这个津液再虚竭，这就不可措手了，所以需要急下，宜大承气汤。这是两方面看问题。那么仲景他搁个少阴病。一方面就我像方才讲的这个，原来是少阴病，那么到二三日，他是急剧传里发生阳明病，有这一种情况；那么另一方面，我们在临床上呢，假设遇着这一种，啊，一般的感冒，这一类的，咱们说是外邪了，啊，那么在初作很短暂的时间，马上发生一个，他这口燥咽干呐，他这外表上他就是“脉微细，但欲寐”，就是有一个少阴病的一个，啊，以少阴病的证候出现，这个就要…与这个是一样的。那么他一发生就这样子，足见里热太厉害，所以他是口燥咽干，那个津液马上就要虚竭，而且人马上就现出虚衰

的外象，以少阴病的形式发现出来。这个，跟…所以读古人书呀，你得根据这个具体事实来研究。那么他并没有开始发生少阴病这种情况，那么他突然间就有这种情况，也准着少阴病传里为阳明病这一种下利，一样治疗，这也得用大承气汤。他因为这里就是说明这个，病来的呀，非常猛暴。啊，津液有立刻就枯竭之势，那么这一类的阳明病，而且人现的一个虚衰证候，这了不得，啊。所以要治病当机嘛，这个时候你要不…迎头…啊，就急下以存津液，那么，转瞬这个恶证峰起呀，那就不可救药。所以有这些问题呀，就得记，没有旁的办法。像那个，咱们讲阳明病那个三急下，与这个少阴病的三急下都是这个情形。

李冠杰：这个条文在《康平本》是顶格排版的条文。

在《宋本》这个条文的后边有大承气汤方和方后注解。

解读一下：

这个条文论述的是由少阴病发展与其他类型疾病当中的一种比较特殊的情况。少阴病因为机能偏于沉衰，疾病进一步发展的话，常常会导致里虚寒的太阴病。但是，人体患病以后，情况十分复杂，在某种情况下，少阴病也有发展为里实证的可能，这个条文论述的就是这种情况。

这儿的“少阴病”，就是指初发的时候为少阴病，或者有少阴病的外观。

“得之二三日”，这个“得之二三日”在这个条文里是一个很重要的眼目。为什么呀？通常情况下，少阴病在“得之二三日”这个时间段里边，一般情况下还停留在阴性表证的病理阶段。但是，这个条文论述的却是刚得了两三天这个时间内，迅速地发展为里实证。也就比较特殊了。

“口燥，咽干”，是少阴病在发病初期就突发为大承气汤证，而表现出来的一个典型的症状反应。因为病程比较短，病情发展得又比

较迅速。所以，往往形不成明显的大承气汤证其他的典型症状。但是，并不等于就没有这一类的倾向。只要有服大承气汤的这个病理条件的话，这种患者在临床当中一定还有其他的症状。比如，最起码他感觉腹满，你要按按他的话，会觉得不舒服或者拒按，他会疼，肯定他会有这一类的症状；或者在少阴病突发之前，就已经有多日不大便的这个过程。但是，这个时候表现最为突出的症状就是“口燥咽干”。这是人体的体液严重虚损的一种表现。

“急下之”，这个“急下之”，被后世称为大承气汤证的急下证。虽然从这个条文的论述上，看不出有什么急下的必要，因为他就是一个“口燥咽干”，就用大承气汤急下的必要吗？要看具体情况。这个少阴病的人体，本来就是偏于沉衰的这种情况，而且少阴病刚得了两三天时间内，就出现了“口燥咽干”，这不仅仅是里实，而且，津液又虚极了。这种情况说明这个病发展得非常快。如果这个时候，稍有延误，没有正确的治疗，很快就会出现一种什么局面？就是人虚病实。就是过了这个时候，人很快就会出现危象了，那就没有用承气汤的机会了。但是，到那时候要补，人虚了用补法吧，病是实病，又没法补了。

“宜大承气汤”，没有用“主之”，言外之意，就是有斟酌的余地。但是，这个条文里边仅仅就有一个述症。所以斟酌依据是什么？还是我刚才说的那个，应该有相应的大承气汤证，尽管不是那么典型，一定得有里实证的证据。这有一个大承气汤放在这儿，就可以去找，或者是大承气汤，或者是小承气汤，要根据具体情况。跟这个条文情况比较近似的论述，后边还有两条。虽然今天在临床当中这一类情况很少见到了，但是，事关重大，关系到生死的问题，不可不知。

这一类的特殊情况，太特殊了。本来是一个机能沉衰的病，很快发展成一个机能偏于亢奋的里实证，现在遇到这一类情况的几率都非常得少。我估计，就是在两千多年以前古人的那个时候，这肯定也不

是一个常见病。它对这一类的情况都有这么详尽的经验总结，可见经方医学真是适用于人类绝大多数疾病的一门比较成熟的医学。

少阴病、自利清水、色纯青、心下必痛、口干燥者、可下之、宜大承气汤、（321）

胡希恕：这个“可”字儿改个“急”，他那儿有个小注，不是，啊，你们看后头 那个注儿就知道了，32，在《玉函经》就是个“急下”。这《玉函经》跟这个书啊，都是王叔和编辑的，那么他这个…啊，两个对照着看好一些，有这一个错的…他本来三个急下证一准儿有的，“宜大承气汤”。那么这一段书啊，根本不是少阴病。这个就是这个，啊，那个，那个，那个…啊… 所谓瘟疫了。那个，那个《瘟疫论》，就是所说这个“热结旁流”啊，啊。“自利清水”，自下利而清水。这个“清”当个动词用，就是大便的意思，就是排便，排出便全是水。这一个“清”啊，古人是四框里头搁个青草的青，清当如厕讲，跟 这个“下利清谷”是一样，下利同时清…啊，他便出来那个都是完谷不是粪，当然它也没有味儿，也没…啊，这个谷物都没消化，所以这都是胃虚的一种说法。这个“青水”不是的。色纯青，这个色儿啊，纯青，就是青褐色。我得过这种病，啊。这个青水，啊，是色儿非常浑浊，发青黑色儿。那么就是污浊之水了，是吧？这一个，啊…味气难闻的很。“心下必痛”啊，所以他这个书啊，这个“必”字它的用法，跟我们前头儿那讲了很多了，你像“太阴阳明合病，必下利”，他就是说这一段，必须有这一个证候，才是这个情形。如果心下不是疼痛，这一个不能说他是内有所结实了。他心下疼痛，他这内里头…他这个病一来呀，开始从胃上结。所以他怎么叫“热结旁流”呢？那个吴又可，啊，一方面结者自结，流者自流。一方面它结，这热的很呐，它结；一方面排斥这个水，啊，往下，感紧下，啊。所以

他这个…啊，结在中，流从…旁侧，流下去。这个吴又可他给起个名字“热结旁流”，挺有意思，啊。就是一方面结、一方面流。咱们一般的阳明病不是的，一般阳明病啊，他这个热酝酿一个相当程度，它是使着水分消失，所以水火这两个东西它不相…啊，不相…所以水火不同炉嘛。火盛了这个水 它自然就要消失。所以阳明病法多汗，啊，小便数，大便硬。他这小便数多汗都是祛除水分，啊，内里头热所以蒸蒸汗出啊。那么这一个，所以“热结旁流”这个来的也猛，一方面结，一方面对于这个水毒的排斥啊，不能出汗，啊，不能小便数，就统统往下排斥，所以这个伤津液，啊，结，都是相当迅速。那么心下这个地方结，他就疼了，啊，就结于心下就是胃这个地方。“口干燥”，同时这个津液，虚燥的情形也反应到口腔上来了。“急下之”，这不急下是不行的，啊。急下当然也得用大承气汤了。我得过这个病，这是…说这话，哎呀，总有四十年前了。我有一天正睡觉，要不我…这个病我最有体会。睡觉啊，我就感觉啊，简直就是这个，整个身体就是晕眩起来了，就像做梦一样，我那一阵儿寻思做梦呢。可是呢，这个难受的很。我当时啊，就醒了。醒了这肚子疼呦，我就往厕所跑，那个时候都在外头，啊。我跑出去就回不来了，嘿，嘿，嘿！后来家里人看我回不来了，那一阵儿我那孩子在我那儿呢，他们去把我弄回来了。就什么？所排泄那个就是“自利清水，色纯清”，那个气味难闻的很，回来我就人事不知了，这东西凶的很呐，啊。这一宿差点没死了。后来他们就是，啊，找一个，找了西医，也是给我，也是急救，打些针。哎，第二天早晨我清楚点儿，清楚点儿呀，并没感觉多大发烧，就是这个肚子啊，这个疼，啊，后来我就想就是这个病。我就吃点这个，不是吃的大承气汤，吃的调胃承气汤，吃了就好了，泻两泡屎就好了。那嗓子干的厉害。所以这一种得病，古人叫瘟疫，它来了，他不是以少阴简单来的，可是这个情形的反应像少阴病，啊，他也是，啊，脉不是那么急躁，啊，啊…而且人呐，困倦。你像我当

时就是，就像现在说就是休克了。那当时什么也不知道，给我打针什么我一点也不知道，嘿，嘿，嘿！所以这一个与少阴病无关。它就属于瘟疫了，你们看看吴又可《瘟疫论》有。那么这个只能够…啊。它这个病来了他就从里边发现。

李冠杰：这是顶格排版的条文。

“少阴病”，应该理解为由少阴病发展而来，或者是初得病的时候形似少阴病。

“自利清水，色纯青”。这儿的“清”是一个动词，是解大便的意思。“自利清水”就是自下利而且解出的大便呈现水样；“色纯青”，“青”在古代常常是黑色，但实际临床中这类情况或者是黑绿色，或者是黑褐色、深褐色这样的水样便，实际上就是被后世称为“热结旁流”的情况。那么，一方面消化道内的食物在不断的结滞，另一方面消化道的机能过分的亢奋，实际上这就是一种严重的病态，它将体内的水分大量的从消化道内排出，形成了一种非常污浊而且里边没有污滓等实质的东西，是这样的一种水样便。

“心下必痛”，这是结实在里的一种症状反应，指胃部或者腹部有疼痛感。实际临床中常会呈现一种硬痛而且拒按。

“口干燥”，跟上条的“口燥咽干”是相同的问题，都是人体津液虚损严重造成的。这条论述的实际是大承气汤证中一个比较特殊的情况。按照经方理论，在出现大承气汤之前有没有少阴病这个过程并不重要，那就成了病因了嘛！特别是这条跟上条不一样，上条那个两三天是有用意的，这个地方没有这方面的因素，所以有没有少阴病的病史并不是特别重要。但是这类危急重症发生，必会有一个前驱的过程，或者之前有一个患病的过程，或是少阴病也好，或其他的病也好。结果会造成人虚了，这是一个重要的。这条论述是由少阴病发展来的，少阴病在这里真正的意义，是因为得少阴病的人机能偏于沉衰，人比较虚。如果本来就是身体非常虚弱的人，得了这类的病，他也可能现

这类的症状反应，就是说大承气汤证表现一种比较特殊的情况。如果从这个基础上去理解少阴病，就比较容易把握了。这个地方的“少阴病”，并不是一定要由少阴病发展而来，是提示这地方就是人体偏虚了。

“可下之，宜大承气汤”。既没有用“急下之”，也没有用“主之”，可见这类情况在临床中有比较大的斟酌余地。这方面的情况，胡老自己有一个医案，他本人得过这个病，但胡老在讲课的时候发生了口误，他说得这个病非常急，到厕所里边就出不来了，就不省人事了，后来是别的医生给打了针，然后就好一点了。他就觉得病没全好，他说的是又用了调胃承气汤。但是胡老在另一本书里提到这个医案，说当时用的是大承气汤与调胃承气汤的合方，就是大承气汤加了甘草。从这一点上看就有斟酌的余地，他为什么用甘草啊？大概感觉到自己有虚的那种倾向了。

少阴病、六七日、腹胀不大便者、急下之、宜大承气汤、
(322)

胡希恕：这一个像是少阴病 转属阳明，啊。“腹胀，六七日不大便了”，肯定这是里实了。那么由于它是少阴病转属，他也要用大承气汤急下之。这要搁着我们，头前那阳明病呢？这一个不能用大承气汤，是不是啊？只是腹胀、不大便。那么他以少阴病的证候反应，他根本是现出少阴病来，他少阴病不应该…啊，一般都不转属阳明。如果转属阳明了，你就不要轻视了，所以这一个应该赶快，啊，急下，去里头结热，啊，这个病可望其速治。所以这几段在少阴病里头啊，也是特殊的情形。

李冠杰：这是个降两字格排版的条文。

下边解读一下：

“少阴病，六七日”，在这个条文当中，可以理解为这个大承气汤证，可由少阴病迁延多日发展而来，也可以理解为这个患者本来就比较虚，因为多日不大便发展为大承气汤证。为什么要加这么一个条件呢？因为在这个作者心目当中，少阴病不是阴性表证，他这少阴病不定说的是什么呢！

“腹胀不大便者，急下之”，如果仅凭这儿的述症，还构不成“急下之”的条件。“急下之”应该有下面这些因素：一个是，他本来患的是“少阴病六七日”，如果说不是少阴病的话，经过六七日也必定是有人虚的因素存在，就是人体已经比较虚弱了。第二，“不大便”必定是在他论述的“少阴病六七日”的这段时间内，一直有不大便的症状，在这个基础之上，又出现了“腹胀”，腹胀这个症状必定是突然出现的一个症状，以前的时候只是不大便，而且有一些阴性证的症状反应，但是经过这么多天以后，突然出现了“腹胀”。为什么这么去理解呢？只有具备了这些条件，这里的“急下之”才有可能，才能成为“急下之”的条件。如果不是这样的话，他本来就发病这么多天了，何来的急下啊？这么多天了，前一两天是不是就该下了。特别是这个“腹胀”，肯定是一个突然发作的症状。

这个条文论述的，实际就是患了少阴病以后（他说的少阴病了），同时又伴有大便不通的症状，一直是迁延数日之后，突然出现了腹胀之类的症状反应，这种情况比较适宜用大承气汤急下。

因为这一类的条文，大都有一定的临床基础，大部分是作者在临床中的所得，所以我们应该给予充分的重视。咱们解析也比较详细一些。

少阴病、脉沉者、急温之、宜回逆汤、（323）

甘草二两炙 干姜一两半 附子一枚生用去皮破八片

右三味、以水三升、煮取一升二合、去滓、分温再服、
强人可大附子一枚、干姜三两、

胡希恕：这个“脉沉”为在里嘛。我们头前儿，头前儿讲一个，啊，“少阴病，始得之，反发热，脉沉者”他要用麻黄附子细辛汤。所以这个病，啊，这个每一段你要看整个的问题。那么这一个脉沉，他既不是始得之，这是第一；第二，也没有这个表证这种发热的情形。所以他这一个，啊，这一个只是“脉沉”，沉为在里呀，啊，那么这一个沉也主有水。你们看那个《金匱》，《金匱要略》那个水气篇就有了。所以“脉沉者，当责有水”呀。我们头前儿那个麻黄附子细辛汤，他怎么不用麻黄附子甘草汤啊？他就由于，啊，用细辛来逐水，逐饮。里头有水饮，所以一方面逐水饮，一方面解表，它那个方子是那样子。那么这一个时候不行了。这个时候他没有“表证”啊，所以他没说“始得之”，那么这一个脉沉呐，里头，啊，有寒饮寒水，所以少阴病里头有寒水非要转成太阴病不可。那么转成太阴病就相当危险，是吧？所以呕吐，下利，同时一来脉，啊，脉微欲绝，再有这个情形这就有死的可能。所以眼觉着，稍见其端，那么脉沉，它不浮，啊。我们讲那个脉微细，它在浮之中的脉微细呀，他是在表啊。这个“脉沉”，这一个不可轻视的，这个里头是有寒饮，转过来他就要腹痛下利，啊，这一种这个，啊，阴寒在里，这个太阴病要发生的，这，发生不就危险嘛，所以赶紧急温之，啊，宜四逆汤。只是能用四逆汤，啊，温其里呀。他因为他讲了三个急下证，啊，说急下证这特殊情形。所以他这个书啊，都是应急自变，不要认为少阴病尽出这个事儿，不是的，啊。那么如果有阴寒在里情形的发现，那就根据治太阴的法子，用四逆辈，啊。这一段就主要这样子。那么为什么他不用麻黄附子细辛汤呢？他没有“反发热，始得之”这一种情况。

李冠杰：这个条文在《康平本》为顶格排版条文。

解读一下：

“少阴病，脉沉者”，这就是典型的简述了，述症就一个脉象。实际上，单纯的少阴病有时候也会出现沉脉。所以这儿只用一个典型的脉象，来阐明疾病的趋势。更多的症状反应呢，都隐含在“急温之”和治疗方剂“四逆汤”当中了。除了“脉沉”以外，还应该有四逆汤证的某些典型的症状反应。

我们还可以联想到第 301 条的麻黄细辛附子汤，跟那个可以参照。这两个方证都说了“少阴病”，而且现“沉脉”。但是病理不同，除了机能沉衰是两个方证共有的以外，麻黄细辛附子汤证的“脉沉”主要是停饮的证候，而这个条文里论述的“脉沉”是里虚寒的证候，以里虚寒为主。为什么把这两个条文放在一块儿，来做一个比较呢？这两个条文再一次阐明了经方理论当中一个重要的治疗原则：一个是表证与水证同病的时候，不可单独解表，必须解表与祛水同时进行；第二个是表证和里证同病的时候，如果里证需要温补的，则先温里，后解表，或者是同时进行。这两条出现在少阴篇里边，就是为了要强调：这些治疗原则不但适用于阳性证，同时也适用于阴性证。而且相应的治疗方药也会有所不同。就是要说明这些问题。

《康平本》有四逆汤的方子和方后注解。在方后注解的最后，有这么一句话，它是另起一行的单独段落。“强人可大附子一枚，干姜三两”。四逆汤原方：甘草二两，干姜一两半，附子一枚。实际上“强人可大附子一枚，干姜三两”，作这样的改动之后，这个方剂就成了通脉四逆汤。很明显这个注解内容是后人所加的。如果顶格条文的作者写的话，绝对不会在这个地方写这个。为什么？如果病重改用通脉四逆汤，不就完了嘛。不会做这种注解的。

少阴病、饮食入口则吐、心中温温欲吐、复不能吐、始得之、手足寒、脉弦迟、脉弦迟者此胸中实当吐之·不可下也、若隔

上有寒饮、干呕者、不可吐也、当温之、宜回逆汤、①（324）

注：《宋本》此条文如下：

少阴病，饮食入口则吐，心中温温欲吐，复不能吐。始得之，手足寒，脉弦迟者，此胸中实，不可下也，当吐之。若膈上有寒饮，干呕者，不可吐也，当温之，宜四逆汤。

胡希恕：他这个头一段呐，不是少阴病，是有少阴病的外观呐。“饮食入口则吐”，他由于胃里头停水，啊，它水往上逆，他要吐嘛。所以饮食不纳，啊，饮食不受，一吃他就要吐。就由于底下这个问题，他“心中温温欲吐”。这个“温温”呐就是“愠愠”的意思。咱们讲《论语》是吧？有“人不知而不愠”，“愠”就是“烦恼”，是吧？就是竖心儿啊，搁这半拉“温”字儿。那么在这个《千金》里头他就改那俩字。“温温欲吐”者就是，啊，说不出来这个这个烦恼，老想要吐。但是呢“复不能吐”，而不能吐出来。所以在这个情形之下，饮食入口则吐，那没问题的，他不受。“始得之，手足寒”呐，啊，这个病一开始他手脚就发凉。为什么呢？他底下有解释，啊。“脉弦迟者”，弦也主有水饮，迟有寒，里头有寒饮就是。这个寒饮往上冲逆呀，啊，所以“胸中实”。这一段看出来，啊，这个中医辨证啊，那么这个在这个病机上来看，他就要吐，就要吐。可是自己这个，这个良能啊，他吐不出来。他这个老想要吐，老想要吐，啊，那就想由吐解除疾病，就这么一种机制啊。这很清楚，啊。你们看看这个吐剂都是这个样子，不是随便拿出个病，我们就要给他吐的。我们应该顺其势而导之嘛，应该吐之不应该下之。那么这一段，他不是少阴病。可是由于这一个胸中实，阻碍气机，是吧？所以脉弦迟。那么人呢，啊，当然也是精神不振了，他老要吐老要吐，温温欲吐，啊。那么而且呢，它阻碍这个血气，啊，旁…旁流，所以他手足也厥冷，啊，这个外观像是少阴病，其实不是真少阴病。跟我们头前儿讲那一个，啊，那一个…“热结旁流”啊，一样的，这个实质不是。这个因为什么不是呢？这个瓜蒂散，啊，这个药可不是一个，是虚寒万用不得的，它

是攻实的。咱们这个汗、吐、下这三…三种治病的方法呀，全是攻实。病实，啊，需吐之，需下之，需汗之，这都是这个。虚寒那没有用吐法的。“若膈上有寒饮”，“膈上有寒饮者”就是胃里有寒饮呐，是吧？“干呕者”，他不是真要吐，他里头没有，啊，没有什么水。只是，不像上边那个，上边那一个，啊，水往上逆得很。只是干呕，他并没有心中温温欲吐，复不能吐，啊，也没有饮食入口则吐，没有这个情形，只是膈上有寒饮，啊，老想冲逆干呕而已，这是在胃里，啊！这就跟头前儿我们讲那一个“脉沉者，急温之”是一个问题。那么假若胃有停饮而发生干呕，没有心中温温欲吐，复不能吐这一种病情啊，你不要认为胸中实给他吐药了，这是真正里有寒，啊，而有水气，啊。那么这一个，那么即刻在少阴病外观，也赶紧急温之，啊。

“不可吐也，当温之”，这一个你别拿当胸中实，给，给吃吐药那就坏了。他这特意，他出这么一段呐，也大有用意的。他让你，就让你辨别这么两种证，有的时候啊，这一种这个，胸中实，瓜蒂散证，像阴证差不多。他也四肢厥冷，啊，脉弦迟，啊，那么这个你当虚寒治就坏了，你吃四逆汤都不行了。那么这个四逆汤证呢，有类似的。他是干呕，没有心中温温欲吐，复不能吐，啊，没有这些情况。这是里头真正的，啊，在胃里有寒饮呐。这与那一个，啊，要吐而不得吐的那一种病是两…两种。所以在临床上这很要紧呐！这两个你要弄错了，生死的关系。“宜四逆汤”。他这个主要给四逆汤立论，啊。这个少阴病不少阴病的，这是，不是个主要。那么少阴病与瓜蒂散，啊，有这么一个，啊，主要的鉴别点在哪儿呢？真正的这个病有欲吐之势，啊。你看看咱们讲那个瓜蒂散，头前儿也讲了不是吗？“气上冲胸咽，而不得息者”，他这个病是整个要往上，往上来，甚至于呼吸都费劲，啊，那你赶紧吐。那么这一个呢，他就是要吐吐不上来，你吐就得了。所以这个治病有一个顺势利导。这个顺势利导啊，就是顺这个病机之势。咱们讲头前，讲这个六经，开始的时候也说过了，咱们说那个太

阳病，啊，这就是病啊，它自己要表解，而不得解。那，那，咱们分析那个证候不也分析了嘛，也确实那个样子。他这，有一个要汗出，出不来汗，这么一种情形，所以古人呐，啊，他通过临床，这一类的呀，一发汗呀就好，啊。他古人他是掌握这一种规律、方法。那么咱们现在呢？根据这个规律方法，再往下透视看，怎么个情形。这个里证也如此的，这个里证啊，这个就是咱们人身这个…这个身体呀，它有一个愈病的一个方式。它就把这个病啊，打算由消化道这方面，或者把它吐出去，或者把它泻下去。就这么来，就这么个情况。那么这自然良能呢，常常的它是达不到……（音频缺如）……有，有一种抗病的这种防卫机制啊，这就西医书上有这样说。但是呢，这里头有，啊，有一个与这个似是而非的，应该温之的不要吐之。这一个他就要发生太阴病了，啊，虽然只是干呕，但里头确实有寒饮，啊，这一个你要不赶紧急救，啊，用这个四逆汤急温之啊，那是马上就能够发生…啊，呕吐、下利这一种病。所以这个治病是个难事啊，啊。不是在已发作这种病了，你像我们讲这几段全是这样子。它要已发作出来了，这一个病就是很费劲救治了。那么在它是看出来它要发作，这一阵儿抓紧机会治。所以良工治未病嘛。这就是谓“未病”，啊。你像咱们头前儿说这个“急温之”，就一个“脉沉”。那么这一个呢？啊。只是有“干呕”，但是也有“四肢厥逆”，厥冷啊！啊，也得有这个情形，他上边他，他是接着上边这一段说的。这一个，啊，也应该啊，应该用四逆汤来温之了。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格排版的条文。

在《宋本》因为将注解内容窜入正文，这条就改成了：“少阴病，饮食入口则吐，心中温温欲吐，复不能吐，始得之，手足寒，脉弦迟者此胸中实，不可下也、当吐之，若隔上有寒饮、干呕者、不可吐也，当温之，宜四逆汤”。这个地方改动得就比较明显了，改动者为了准确表达他的意思，等于断章取义了，旁注内容把正文给截开了，形成

了一个比较严重的问题。我们下边一点一点地分析。通过条文的改动，康宋两个版本比较一下马上就能看出来，《康平本》绝对不会是假的，没人能用《宋本》的样式改成那个样子，这个条文也能证实《康平本》的真实性。

解读一下：

这条因为把旁注内容窜入到正文，对原文的本意影响非常大，近两千年以来误导了所有的读者。如果参照《康平本》把旁注内容剔除出去，条文的原文是：“少阴病，饮食入口则吐，心中温温欲吐，复不能吐，始得之，手足寒，脉弦迟，不可下也，若隔上有寒饮，干呕者，不可吐也，当温之，宜四逆汤”。条文论述的是四逆汤证中因为胃虚停饮，而致使患者出现“饮食入口则吐，心中温温欲吐，复不能吐”这类症状，这是一种情况；另一种情况是因为“隔上有寒饮”而致“干呕”的。这两种情况是四逆汤证中相对比较特殊的。而且明确指出了前者虽然有“饮食入口则吐，心中温温欲吐”这些症状，也不可使用下法，这不是实证。后边的情况虽然有“干呕”，也不可使用吐法。这两种都属于四逆汤证中的比较特殊的情况，所以应该“温之”，用四逆汤来治。这是原文的大致本意。

但是，经过后人加入旁注，特别是《宋本》把旁注窜入正文以后，条文的本意就完全给歪曲了，特别是上半部分跟原文的本意大相径庭了，几乎是相反。咱们看看：

“少阴病”，在这应该理解为由少阴病发展而来或者有少阴病的某些特征。

“饮食入口则吐”，就是吃了东西入口就会吐，在这个条文中属于里虚寒证，而且偏于胃中停饮的一种情况。

“心中温温欲吐，复不能吐”，是指患者不单单是“饮食入口则吐”，即使是平时不吃东西的时候，也因为胃虚停饮严重而常有欲吐不吐，心中自觉泛泛不适的感觉。

“始得之”，就是上面说的症状刚开始得的时候。“手足寒、脉弦迟”、“不可下也”，就说上面的“心中温温欲吐，复不能吐”这种症状又伴有“手足寒，脉弦迟”的，肯定是里虚寒所致，所以“不可下”。里虚寒证再加上偏于停饮，不可用下法。

“若膈上有寒饮，干呕者，不可吐也”，是说如果此时“膈上有寒饮”的，还可能出现“干呕”的症状，“干呕”和“心中温温欲吐，复不能吐”还是有一定差异的。欲吐不吐，老是有想吐的感觉，还形不成吐的症状；“干呕”是典型的“呕之有声，吐之无物”的症状，这种病人常见。但是这两种证的发病机制实际上是相同的。在这儿之所以把它单列出来，就是重在强调虽然有干呕，但是它仍然是里虚寒证。虽然看着有上逆的趋势，老干呕嘛，但也没有使用吐法的机会，因为它是里虚寒证造成的。所以后边说了“不可吐也”，应该交代得很清楚了。

这条的旁注的作者怎么改的呢？他肯定认为，论述中“若膈上有寒饮、干呕者、不可吐也”，言外之意就是前边的“不可下也”的情况应该视为可吐的情况。如果不是这么想的，他不会加这么个注解。这个注解是一种理解上的偏差，是旁注作者自己的认识，本来无可厚非。但是《宋本》把这些内容一下子加到正文里去了，篡入正文了，这个问题就严重了，就把原文中的“心中温温欲吐、复不能吐”变成了可吐的瓜蒂散证了。再看后边的症状，就延伸出了瓜蒂散证中也可以出现“始得之、手足寒、脉弦迟”这样的症状了，就把四逆汤证歪曲成了瓜蒂散证。这种歪曲形成后，后世解读的人有天大的本事也想不到，因为它已经融到一块儿了，分不出来了。在没有《康平本》参照的情况下，所有的读者都是那么解释的，因为看字面的意思就是这样，还能做出别的解释吗？所以误导了所有的读者。拿《康平本》一对照，才会发现这条根本不是这么回事！

少阴病、下利脉微涩、呕而汗出、必数更衣、反少者、
当温其背上、灸之^①、（325）

注：“当温其背上、灸之”《宋本》作“当温其上，灸之”。

胡希恕：这一段相当的好，啊。这一个你们看看头前儿那一个“少阴病，下利，脉微者，与白通汤”。这跟它，它就，这一段叫我看呐，就承着那一节儿来的。这个“脉微”呀，在仲景这个书，他是提出多少回了，啊。“脉微者”为亡阳啊。亡阳就是亡津液，没有津液。这一段你不光微而且涩，“微”则“津液虚”，微；“血液虚”则“涩”。这说明津液血液俱不足啊。那么“少阴病下利”要有这个脉你不能发汗。咱们所以那个白通汤，你们还记得吧？少阴病，啊，下利，脉微者，与白通汤。马上就是一个巨变。所以那一段书，大家解释得，我很…啊，我很不同意…不同意，啊。说是不是药有所误。上次咱们也讲了，啊。这是说是啊，大寒之病，咱们用这个热药，啊，这个病啊，反发生格拒了，啊。得怎么办呢？得加点凉药，啊。这个热药凉用他就好了，所以白通汤加猪胆汁。说的是很在行，是吧？很…很像。所以我开始研究伤寒论呐，开始学习时候我也信。可是后来我越看越不对，它明明是错了。因为他头前儿，啊，“少阴病，脉微者，不可发汗，亡阳故也。”它头一段“少阴病，下利，白通汤主之”那非常肯定。当然吃白通汤就好了。白通汤是个发汗药，它以大葱为君。白通啊，通什么？就是通津液以致汗嘛。那么第二段他提出来了“少阴病，下利，脉微者，与白通汤”，啊，他就要是干呕，烦躁，等等的，脉，脉也没有了。那还是药无所误？那纯粹是误了。脉微者，不可发汗。这一段就是从这上来的。怎么治呢？他这个怕你不明白，它不但“微”还搁个“涩”。说明就是津液血液不足。为什么不足？你看这个情形就知道了。一方面下利，一方面呕而汗出，啊。他津液丧失于上、于下、于外边汗，这有虚脱之象啊，你可知道啊？所以脉

应之既微而又涩，所以这个样儿情形你放心，他不会，啊，泄下无度的。“必数更衣，反少者”，他一会儿跑茅房，一会儿跑茅房，他这失去收摄嘛，他虚的不得了。可是呢，没有多少东西，因为津液有枯竭之象了，“脉微涩”，啊。津液不足，血液也不足。他没有什么可泄的，你可知道？所以他搁个“必数更衣，反少者”，所下的东西是有限的，啊。底下他更什么了。“当温其上，灸之”。这个“当温其上”这个注家也闹的可热闹了。他没有，没指出穴来，这个“当温其上”啊，这个注家们就说了，最上是哪个穴啊？百会，脑袋顶儿，啊。应该灸这一个地方，这是瞎说八道。他这个下利呀。我们回头想一想头前儿讲的，啊，他有两种。一种应该在中焦，咱们头前儿不有个下…利不止，啊，与理中，理中者，理中焦，不行，啊，吃了理中汤利反更剧。所以此利在下焦，那么与禹余粮汤，那么再不止，可以利小便。所以一利小便或者用收摄，啊，固肠的药都是治下焦。他这一个他告诉你了，应该治上“当温其上”。治什么？治胃。他这胃这是，胃虚。这一个津液虚衰呀，这个，啊，这个地方咱们值得讨论呐。这个津液虚衰，也有两个不同的情况，你像我们头前儿讲那一个“急下之”，啊，口…口，啊，口燥咽干，那是津液虚，是由于热。那你非得想法子，啊，要如果实就得攻，下之以存津；那么如果不实只有热我们用白虎汤加人参那个法子，是不是？清热，也救津液嘛。那么这一个纯粹由于什么？就由于胃太虚衰了，他不能够生津化液，而且还是，啊，那么一切证候都是一个，啊，虚脱的一个象…一个象征，“上吐下利而汗出”这都虚脱之象。这一个你非治胃不可，胃气存在，津液自恢复。所以我们后头要讲霍乱的时候你就知道了，啊。有很多呢，这个津液虚竭了，他由于胃的这个衰败，你非得亢进胃气不可，这一个时候啊，一点滋阴药也用不得。一用滋阴药再坏其胃非糟糕不可。这一个咱们容易犯这个病啊，啊！有些搞脏腑辨证的，动不动这个虚了，那个虚了，啊，阴虚生内热，那你，啊，地黄、麦冬上来就要命。

这一个就是不行的。这一个他只是你温其上，当温其上，温胃，应该用四逆汤，啊。他这后世就认为津液虚呀，这一个干姜、附子不能用，这才错误呢！那个《医宗金鉴》那都是，这些太医院的老爷们都那么说嘛！这个东西它误人不轻啊！！他这个津液衰就是由于胃，它不能消谷，哪来的津液啊！你恢复一分胃气，就恢复一分津液。这个地方这个书里头多的很，啊。这很重要很重要的。这个时候要你温胃，什么呢？四逆汤。灸，据我的看也不是灸，啊灸百会，啊。准是灸三里，温胃嘛，是吧？所以仲景他这个书，我上次讲一回，是这个穴位他都不提，为什么？咱们想张仲景那个当时啊，那个针灸极普遍，一说大家都明白，那一阵儿是不成问题的事儿。所以到后世都成问题了，啊。所以中医在这个晋以后，南北朝的时候乱，是有些退步，啊！那么大家就对这个穴，胡揣。这一段很好，同时呢，也说明头前儿这个白通汤，那么少阴病，下利，如果脉微呀，只能温上，你不能在发汗了，所以白通汤是错的。那么后来加猪胆汁也一定加到通脉四逆汤，也绝不会加到白通汤上的。所以这个书，这个错误是有的，啊。这一个，啊…因为，啊，小两千年来了，啊，大家传抄，啊，加上后人往里头乱填，啊，这个事儿是有的。所以咱们上次讲那白通汤的时候，就讲这些问题了，所以这个大家值得讨论，啊，研究嘛。所以咱们读这个书啊，不要死肯它，啊，这一句话就是这个，那么注家犯这个毛病，他就要啊，啊，圆这一个，原文之说。

李冠杰：这是个降两字格排版的条文。

“当温其背上、灸之”，《康平本》是“炙甘草”的“炙”，《宋本》里边成了“当温其上、灸之”，“灸之”是对的。“当温其上”少了一个“背”字，这个问题也挺严重，这一下也是把后人给误导的猜什么的都有。

咱们下边解读一下：

要准确地解读这条条文，必须先弄清楚两个问题：其一、这个条

文必定是作者临床经验的总结，也就是说这个作者在临床当中用灸法治愈过这一类的病；第二、如果仅仅用灸法可以治愈的病，一般都不是危急重症，这是必须弄清楚的。弄不清楚这个就很容易读偏了。而且这个条文历史上几乎都读的有偏差。当然我也不能说我这个就对，但是大家听听有没有道理？我们带着这两点基本理念，你再来看看这个条文的论述。

“少阴病、下利脉微涩”，可以把它理解成是有少阴病提纲条文当中的“脉微细、但欲寐”这一类的症状，同时又伴有下利。“脉微涩”，按着这个作者，因为他是搞脉学的嘛，他对脉的定义，他就是想说这是一种津虚血少的脉象。

“呕而汗出”说明这个时候的人体表里俱虚，表虚不固，不一定有表证，但是他已经是表虚不固，有汗出，而且里虚还有呕。

“必数更衣、反少者”，这个“必”咱把它理解成“如果”就可以了。意思就是说在上边论述的这种情况下，如果出现大便次数多，而且大便的量反而又少的话，就可以用后边的灸法治疗。

咱们来看看它到底是一种什么样的病，就用灸法治疗？假设这是关系到生死的急性重症的话用灸法，咱们得重新审视灸法，好多方剂就没有用了，用灸法多好啊，又没有副作用，也不用去辨证。

“数更衣”就是大便次数多，前文有个下利，这个“数更衣”不是前头下利的一个简单的重复，是为了后边的这个“反少者”。它与“反少者”一起来强调虽然大便的次数多，但是量却很少，他强调这个症状的特点。这个症状与前边所述的“少阴病、下利脉微涩、呕而汗出”，结合到一块儿来理解，它就能反应这个患者的疾病状态。实际上这个时候的患者这个病势并不重，因为他本身就处在一个津虚血少的这种情况下，他又出现了下利，可是他下利的量又少，说明这个时候，跟他的津虚血少的状态是相吻合的。就是说这个时候的里虚寒证比较严重，但是他又津虚血少，在大便上就反应出来大便的量少。

就说明这个人还没有发展到人体自身对大便无力收摄的那种程度。如果患者表现为狂泻无度的话，那病势就非常严重了！那就不是灸法能治疗得了的了。所以说从大便量少这一点，就反映了人虽然有里虚寒证，但是没到人体无法收摄的那种程度，病情相对说还比较缓。所以说这个地方作者就建议用灸法。

但我们这儿不讨论该不该用灸法，既然他写在这儿，肯定有用灸法治疗好的。今天我们虽然讨论这个，恐怕我们在座的有好多是针灸的高手，也许你能用针和灸治疗这些疾病，恐怕临床当中治疗这类疾病的机会比较少。

“当温其背上、灸之”，因为《宋本》少了一个“背”字，所以后世的学者把这个地方都误解了。其实《康平本》里边交代的非常准确无误，原则上他给你交代的很清楚，是用温法，具体的方法是用灸法，具体的部位是背上，这已经相当清晰了。

这个条文实际就是论述的阴性病当中，以“呕而下利、脉微涩”为主要症状反应的这么一种比较轻的疾病状态。病情的证据就是大便虽然次数多，但是量非常少，说明人体主要是以里虚寒为主，程度不是特别严重，所以作者就建议用灸法。咱们学习少阴篇最后这两条，我们今天借助于《康平本》的理解，和历代的伤寒学者的观点都不一样。我在这儿就只能跟大家说：我经过推敲感觉这么理解，比较贴合本意，大家仅作参考。

少阴病小结

胡希恕：那么少阴病那个病啊，历来的这个说法啊，都说少阴病，不敢说它是里，啊，表证。其实它是明明白白是表证。你像头前儿咱们讲的很很清楚嘛，少阴病，始得之，啊，啊…，麻黄附子甘草汤微发汗，以二三日无里证故也。他没有里证，他不是…他就冲表证说的嘛。那么为什么这些读者，是吧？以至于这个注家，他不怎么说呢？有一个问题。就是咱们把这个六经啊，看成经络之经了。他少阴病嘛，少阴肾经，啊，那怎么跑出表来了呢？啊。就是，就犯这个病了。所以这个六经这个病存在的，我们现在临床上还是有。咱们遇到这感冒都是太阳病不是嘛啊。太阳病几天，这个人就是，啊，虽然脉浮，它细了，也身倦无力了，那不就是少阳病嘛？就咱们说那个“脉浮细而嗜卧者，外已解也”，那么如果再恶心，啊，现柴胡证，你就用柴胡汤准好嘛？这我们在临床不也都常见嘛？这一个东西它是客观存在。太阳病是不是太阳经？这成问题的，啊。所以咱们研究古人东西呀，尤其我们研究，啊，这个《伤寒论》。他这个，必须首先掌握他的，辨证的这个方法、规律。这六个类型，这是事实。那么古人也经过千难万困，他发现它了。昨天我还给几个同志还谈这一个呢，中风啊，伤寒呐，都是这个。太阳病有两个类型。一个呢，啊，就是有自汗的，有自汗自然脉就浮缓，啊，那么这叫太阳中风，因为他出汗自然就恶风嘛；没汗的，没汗的脉它就要浮紧，它里头这个血液充实，他没有，一点汗也没出嘛，那么他必恶寒，啊，他…或者不恶风，或者少恶风，他不出汗。你像咱们在…这天里头，你出一身汗，他就怕

风。尤其在澡堂子你洗完澡，那身上老感觉着这个激激冷冷的，你非披上点不可，你在伏天也是那样子。可是古人呢，他就说什么了，他看着你恶风，这就有风邪，他就给你起名叫中风。所以这个名字不好起的。跟那太阳病是一样，少阴病。恶寒，就寒在那儿呢，寒邪，那他就叫伤寒。这一个，这一个错误啊，不是只是这一个，啊，这么一点错误，这影响整个中医。由于中风，咱们用桂枝汤治中风证，这也事实啊！通过临床你用桂枝汤治这个汗出这种感冒他是好嘛？那准好。可是桂枝汤是散风吗？就由于他治中风，桂枝汤也是散风，这就把药物这东西统统的都弄…根据这个就下来了，这都是错的。伤寒就是伤寒邪，这都来了。从这个辨证，啊，以致于咱们说啥，说这个病理，说伤寒呐，就是这个《伤寒论》那个伤寒了，不外乎受风邪受寒邪的。这于是乎就出来“温病”了。他温病呢？它从里头来的，里头热，他就是阳明病嘛，那没有什么，啊。啊…他不敢说是外边风寒了，他说这一个是口鼻入的，根本就跑到里头去了。这都是从这一个，读《伤寒论》读出来的你可知道啊！这个东西就把中医呀，是越弄越支离。于是乎又出来这个温病这一套，啊，营卫气血呀，又是上焦，中焦，下焦的说这个。根本，他这个书，啊。那么开始在太阳病里头，他就说是“发热而渴，不恶寒者为温病”，温病怎么办？你到阳明病篇看去吧，都是。阳明病里头，只是不是胃家实，那白虎汤证，那不，那那，那温病一卷书，主要的还是得清热，不能够发汗，不能够吐，不能下，更不能温针。那说的很明白嘛，谁让你“温病”当“伤寒”治了？啊，当伤寒表证治了，没有那么说呀。所以这个地方啊，很，很重要，很重要。所以中医，根本他古人怎么办呢？他没法子，他为什么这个病有一个出汗的，有一个不出汗的？有一个恶风的，有一个他不很恶风的？他要说明那个道理，但是限于科学水平他是没说。他就拿现象儿当本质，就这么个事儿。这还是好的，再不然就是拿脑袋臆测，主观。你像我们说这个，这个太阳病，他就说是太阳经，这

个原始是这样子，因为那一阵儿这个经络之说就有了。所以在《汤液》上啊，他也是搞这一个，啊。这个太阳病就是太阳经受邪发病，就有这个意味嘛！这其实是错了。所以我们研究这介古人东西呀，规律一个，怎么样的认识规律又一个。我们想提高中医，就这个认识方面就得提高，是吧？不的话不行啊，拿着，啊，中医治病，我…据我的体会很有疗效。有些就是西医不能治的病中医就能治嘛。可是这世界对于中医的这个，啊，看法，与我们的实际的成绩可差的太远了。世界看咱们是不科学的，不科学不是…就是咱们这个方法，没，没整个给人家看，给人家看那个全是不科学的一套东西，你可知道？所以人家瞧不起中医，就在这一点！你就拿着伤寒病说吧，名字，啊，伤寒杆菌，人家给你看，给你弄得清清楚楚的，你还非得说是受…受了寒邪，或者入里化热了，你还得这么说，你这不是…那科学证明的东西你别再跟人家瞎谤了，你还谤什么？摇头晃脑的，是不是啊！所以中医犯这个病，啊，我是个中医，我敢这么说，我要是个西医，我不敢这么说，啊。中医咱们这个本身是犯这些病啊。现在这个，啊，这个脏腑辨证，我不爱说，一说这里头…不怎么合适，哈，哈！是成大问题的，真成问题呀！你现在咱们都是大夫，是吧？你们哪一个，不天天搞辨证嘛？你辨跟他辨准不是一样儿。要能辨成一样儿那就算合适了！为什么不一样儿？真理能不一样儿吗？不一样儿能是真理吗？能是个正确的东西吗？你想一想。一个病，你马上，四个人分十个步骤，就那一个病，让你辨完了，完了让他辨，他准辨不出一个样儿来，也不能开一种方子。我们要学这个东西呢，就不一样。你不信你就试试。他这非常肯定啊。你像“发热，汗出，恶风，脉缓”，他就要用桂枝汤主之，没有第二个说法。他这个就是，啊，太阳表虚，你只能这么来说来，还能说什么？啊。所以咱们这个辨证啊，是成问题的，怎么不成问题你说？你们在临床上考…考…考虑考虑，是不是有这些问题。我们这个少阴病就是这样子，本来他是一个表证。这个表证为什

么这么复杂呀？咱们讲…讲…讲完了。你像这里头有嗓子疼，又是急下，这是，这是表证吗？不是啊。太阳篇也这么讲的。咱们太阳篇里头调胃承气汤啊，四逆汤啊，讲的很多了，是吧？他这个表证不能老在表上啊，他要传里的。这个少阴病传里，传半表半里与太阳病传里传半表半里一样。他张仲景这个书是表里相传，表证就要传里，传半表半里。不过这个少阴病传里，传半表半里，与啊，与这个太阳病的传里、传半表半里，他这个基础是不一样的，少阴病虚，什么虚呀？就是津液虚，血液虚。它传里以传太阴为常，而且在表这个时间最短，只是两三天。所以他说是，啊，“二三日无里证”啊，那么要过二三天呢，他就要传里。阳…太阳病不是的，太阳病五六天传少阳，七八天才传阳明呢，这是一般。特殊的十几天，还有时候还不传呢，是不是？他在表的时间长，为什么？他实，啊，他这个人不虚呀。虚对病的抵抗在这个表的时间它就短，而且传里以传太阴为常。那么太阳病传里呢，以传阳明病为常，这都是一般的事儿。而且人的生死啊，这个胃是人生之本呐，全在于胃。这个人死大概都在太阴病的阶段多。如果胃气败，必死。所以少阴病本来就虚，传到里发生太阴病就危险的很。所以他把太阴病的死呢，都搁到这个少阴病上，这，这很好。这个书的精神这是好的很。所以这一个，啊，少阴病这几个死症大家好好看一看。那全是少阴病传里而并发太阴病。这都有死亡的可能。所以他开始他有这么几段…啊，几句话“二三日无里证”，这个时候你掌握机会，赶紧发汗呐。可挽救他传里发生太阴病这个危险证候的出现。所以他后头“急温之”等等的，都从这上来的。要当机自辨，这是他这一…这一…这一章 书里，是主要的，啊。传半表半里呢也是一样的，传少阳很少，传厥阴，啊，传这个，这个，这个，传厥阴的多。厥阴，啊，咱们说这个气血这一套东西都属于厥阴了。传厥阴就虚衰，也可以致死！他这里头也有这么两段呐。所以少阴病，啊，他有这些情况。但是要是，有的特殊情形，他也可以传里，他随着人

的身体呀，一看人的这个津血虚，他胃肠素，素热，他要传里他就发生阳明病，那更了不得了，啊。发生阳明病，津液虚竭，燥结迅速，啊，这都是不能当一般的看。如果少阴病传阳明，真见这个津液虚衰之端就要急下。所以“口干咽燥者”就要急下。那么传到少阳呢，也有啊。他也举例子了，你像这个，啊，这个“咽痛”等等的都是的。这个口苦咽干，这是应该，应该归少阳啊，这孔窍这一类的，一类的病。那么这是少阴病的，这个主要的，我们应该注意之点，是这些东西。不过这个名字啊，是值得考虑，将来咱们把这个厥阴病讲完了，把这个六经我再好好给大家说一说，啊。我们六经应该怎么样来认识它。不是不好认识，能够认识，啊。那么古人呢，也没法子，他限于当时的科学水平。我们现在…这个条件比那好得多了，啊，因为古人东西，咱不光看《伤寒论》，还看看旁的东西了，我们还多少有一般的科学常识了，专门咱不够了，科学常识大概都有，是吧？所以咱们就应该…所以这个，啊，这些年了，啊，说要提高中医理论就是指的这些。是得提高，不提高，这个中医呀，早晚这是有不行。他必须科学，啊，非与科学见面不可。那么中医这个治病的精神究竟其实在哪儿呢？我们讲完了咱们好好，啊，好好谈一谈。今天咱们就讲到这儿了。我打算讲点厥阴病呢，我看不行，啊…，讲头前儿没用，啊…等下次咱们再讲吧！另一种啊，有一种习惯势力，啊，就说少阴病，你要说是表证，马上有人就反对，是吧？第三种呢，是这个阴病还是少见呐，这个阴寒病啊，是吧？是少见的。你就是太阴病也少见的。咱们说，平时临床上啊，全是在这个三阳病多，这个三阴病的确少见。但是少见他确实是有，啊，你要临床多了话那就遇着了，是吧？他少。因为这么几种关系，所以谈到三阴病啊，这个大夫心也没主。因为他也没见着过，是吧。哎，他就是看看有这个注家这么说的，他就没法子不这么说。这是有这些问题的。

李冠杰：把少阴篇学完了以后，对整个的少阴篇我们也简单地做

一个小结。

少阴篇从第 281 条至第 325 条总共有条文 44 条，在《康平本》当中，少阴篇包括了顶格条文 20 条，降一字格排版的条文是 5 条，降两字格排版的条文是 19 条，跟顶格条文比较接近了。通过学习少阴篇，意义最重大的都莫过于少阴病是阴性表证的这个定义。原因我们前边已经多次地说过了，就是受《内经》理论的影响，中医界历来将少阴病理解为心肾经络的疾病。就因为这个，所以在临床当中严重得影响了经方的正确运用。

直到近代，胡希恕先生经过几十年的潜心研究，才得以还少阴病的本来面目。同时，胡希恕先生在临床当中也是中医历史上少有的应用经方最纯，临床疗效最好的一代临床大师。这也证明了他的这种理论观点的正确性。如果说他的理论有偏差的话，他的临床疗效不会这么好。

少阴病的本证，也就是阴性表证的基础方证一共有两个：一个是第 302 条当中的麻黄附子甘草汤，这是少阴病当中的实证，也就是阴性表证中的实证；另一个是太阳篇中第 20 条里边的桂枝加附子汤，这个方证是阴性表证当中的虚证。实际上这个与阳性表证当中的情况是完全一样的。表证的基本类型：就是在机能偏于沉衰的和机能偏于亢奋的这两大类情况，每种情况只有一虚一实之分。那么其他的，看似表证的其他方证，或阳性表证，或阴性表证，都是在表证的基础上与其他类型的疾病合病的各类的情况。比如说麻黄细辛附子汤证，这个方证一般情况下大家都认为这就是一个阴性表证的方剂，但是同时有停饮的情况，也就是说它有水证。在我们的病理辨证体系里边，把水证作为一个单独的疾病类型。这样就非常清晰地把表证，就像水落石出一样，掺杂在里边的一些其他类型疾病的方证，就慢慢地沉下去了，最后突出来的就是一虚一实。

另外还有表证的虚实之间的错杂的情况。比如麻黄桂枝各半汤

证，这当然是在阳性表证里边举的一个典型的例子。从这个原则上我们可以延伸出来，在阴性表证也应该是，至少理论上说也存在此类情况。如果辨证准确，它就是虚实错杂的话，也完全可以把两个方剂合在一块儿应用，这是没问题的。但实际临床，至少从我们现在知道的医案当中，在阴性证当中，把麻黄附子甘草汤和桂枝加附子汤合在一块儿用的，比较少见。这可能跟本身是个阴性证有关系，我曾在临床中遇过什么实际情况，就是说他有明显的柴胡证，但是又有阴性的表虚证，结果用了桂枝加附子汤以后，柴胡证没管他，自己慢慢就好了。也能从中品出这个阴性证和阳性证之间还是有一点点区别的。

少阴篇当中，少阴病之外的这些方证的意义，咱们也简单地回顾一下。在少阴篇当中除了典型的阴性表证之外，还论述了许多其他类型疾病的一些方证。这些方证大致可以分下边几类情况：

一类是阴性表证与其他类型疾病合病的这种例子，比如：麻黄细辛附子汤证和白通汤证，一个是和水证同病，一个是和里虚寒证同病。

一类是由于少阴病失治或者是误治而容易发展成的一些方证的例子，比如：附子汤证和桃花汤证。

另一类是少阴病当中可能出现的一些危急重症，比如：大承气汤证和通脉四逆汤证。

还有以“咽痛”为主要症状反应的一系列方证。

这些方证以前是不是在少阴篇里边，我们现在不得而知。但是，我们把它单独作为一部分自成体系的一个方证群就可以了。

还有，在少阴篇里边对表证的治疗原则，进行了再一次的强调和重申，比如：表证与水证同病的时候，这就要解表祛水同时治疗；表证与里证同病的时候，如果里证需要温补的，要先温里再解表。等等这一类的治疗原则，在少阴篇里边也或多或少有所强调。这一类的治疗原则在太阳篇里边已经讨论得非常全面了，在这里的意思也就在于说这些原则也适于阴性证。

少阴篇虽然文字不多，特别是顶格条文就只有 20 条，但是我们整体解读，我们仍然可以清晰地看出，少阴篇再次论述了经方理论当中表证是一种浅表性疾病，如果因为失治或者误治都有可能发展为更为严重的其他类型疾病这样的规律。

但是无论有没有因表证误治，或者是失治，对于任何疾病，它的治疗都必须遵循一条始终不变的原则：就是方剂皆要与症状相适应，也就是说方证相应。这实际上就是经方医学对人体疾病发展规律和治疗规律的认识和总结。

通过对少阴篇的学习，我们应该充分的认识经方医学的重大意义。大家去看一看，胡老在少阴篇的小结里边总结得比较的细致，面儿也比较宽，可以说用的笔墨也比较多，总结得非常好。我们在这儿用一些更细微的、更具体的实例和观点，也来分析一下，我想阐述一个什么样的理念呢？学经方可以提高你的理论层面。我们大家一般来学经方，都抱着一个最直接最实用的目的，学了经方以后，我临床疗效就会提高。但是实际上你要真正走到经方的理论体系里边来，你就会发现，经方理论能够提高你的层次，在人类医学理论当中的层次。

就以目前的 H7N9 禽流感作为一个例子，我们简单地剖析一下。这个病至今找不到稳定的传播途径，或者说是发病原因，既然找不到非常确信的传播途径的话，那么人为什么发病呢？这个禽流感的病毒怎么来到人体上呢？可以说到现在，还没有一个能够令人满意的答案。原因何在呢？这就是由于现代医学，你看它掌握着最先进的科学技术，但是到目前为止，实际上对人体的研究，还应该说是非常肤浅和片面的。事实上任何疾病，外界的致病因素只不过是一个诱发疾病的外因而已，仅仅是疾病的一个方面，人体由于自身的状态不佳而导致对某种致病因素的抵抗能力的下降，是发生这一类疾病的一个非常重要的因素。有一个铁的事实，就说我们人类自有文明记录以来，发生过若干次的大的瘟疫、大的传染病。而且发病率很高，死亡率也很

高，有一些传染病，成千上万的人都死掉了。但是即使这样，也没有哪一次的传染病能致使所有的人都能传染上、所有的人都会死掉。那些不死的该作何解释？说明什么啊？说明越是传染病传染得凶，这些生存下来的人，越说明他们有足够的，至少对这一种病有足够的抵抗力。这段时间我一直在关注着这个，每天我都有那么一段时间看一点新闻，现在几乎每天都会报道，逐渐的会反映出来，现在这个禽流感，得这个病的人，全是些体质虚弱的老弱病残，有一些个别的有儿童，全是这一类的人，青壮年非常少。这本身就能说明问题。实际上人体自身抵抗能力的不足，这才是真正的致病因素。这是内因，而且是主要的因素。今天的禽流感之所以找不到稳定的传播途径，实际上站在这个角度看，它本身就是一个最好最现实的例子。如果用经方医学的理论来认识这个病，你便会与现代医学的认识，形成一种鲜明的理念对比。

当然张仲景不会站出来给你说、给你解释今天的 H7N9 疾病吧，你要从他的这些理论观点里边去寻找规律性的东西。你只有把他的整个的、完整的体系真正学成了自己的，然后在这个基础上你再去看这些问题，都清清楚楚的。在经方医学当中，无论是什么样的疾病，辨证的基础是重证不重病因。这个重证不重病因，我们在学习过程当中一直在说，当你在把它跟我们现在身边的这些现实的疾病结合在一块儿的时候，你就会发现，它实际上有非常重要的现实意义。你应该把研究的重点放在，人得了这种病有什么样的规律性的症状反应。这一类的流感，无论是 H1N1 也好，还是 H7N9 也好，或者是别的什么致病因子造成的疾病，只要是症状反应符合什么方证，你就用什么方证来治，都可取得满意的疗效，这可不是说空话。现在我看了有这样的报道，虽然我没法去核实它的真实性，我想这不是空穴来风。在这次 H7N9 的治疗过程当中，中医介入了，使用了什么方剂呢？银翘散合上白虎汤，取得了满意的疗效。虽然说不是全用的经方，但是治疗的

理路是非常清晰的。这就是一种什么证？阳性表证合并里热证的这种病理状态。如果用纯经方的话，完全可以用。但是出这方子的也是一高手。为什么？这本身就是一个麻杏石甘汤证，但为什么不用麻杏石甘汤呢？麻杏石甘汤在临床当中有一个很大的缺陷，不能连着用，最多吃两剂，你再连着用，人一直在出汗，人很快就出虚了，像这种重病不合适。假如要是让我治的话，我在临床当中像这个啊，我会用麻杏石甘汤合上越婢汤，实际上越婢汤加杏仁。而且前一段时间甲流比较流行，来我这一般都是疑难病的多，来治感冒的都是熟人什么的，来一个一看是个热证，来一个是个热证，我就给他这个方子吃。这个可以连着让他吃四五天没问题，基本上是来一个给他几天的药就不回来了。后来见到，问怎么样？好了。

与现代医学比较的话，中医所用的这两个方剂，显然不是专门为H7N9所设的，自然也没有杀灭这种致病因子的功能。但是这里的方剂实际上就是中医治病的原理：可以调整人体的内环境，使人体恢复患病之前原本人体应该有的足以抗拒致病因子的这种能力。说得再简单一点，有时候这一家人，父亲得了这个病了，儿子没得，这个方剂就能使他抗御这种疾病的能力，达到他儿子那个水平，他自己有了抗病能力，病就好了。或者换一种说法，它可以使人体摆脱目前的这种病理状态，疾病随着人体的恢复也就痊愈了。

从这儿我们可以得出一个无可争辩的结论：经方医学和现代医学不在一个层面上。你去比较就行了。

我们再看看传统医学，也就是说经方医学以外的其他中医，看看它与经方医学的差别。与经方医学比较，传统医学有现代医学相同的问题（可能有一些传统医学理论比较扎实的同道不爱听这个话，但是这是事实），思维方式相同，把研究的重点放到了外界致病因素对人体的影响上，或者是人体某个具体部位的具体病变上。我们现在不是刚学了少阴篇吗？我们就以少阴篇当中的四逆散证为例。这个四逆散

证，我在整理资料的时候，经常去参考一本《伤寒论方证证治准绳》，这全是很多医案统计起来的数据，实际上非常重要。四逆散证比较典型性，非常能说明问题，我们取其中的一段内容，就说四逆散证发病与季节的关系，我们以这个为例。咱们看看典型的传统中医的理论是怎样解释的，怎样分析的？下面我给大家读一段它的原文，一字不差的：“414 例医案中，有发病时间季节记载的 278 例，各季节发病情况如下表（这有一个表），春季发病的有 89 例，占总发病数的 32%；夏季发病的是 73 例，占到 26.3%；秋季发病的是 65 例，占到 23.4%；冬季发病的是 51 例，占到 18.4%；（这是一个统计数据，下面他开始分析了）。表中所示，四季皆可发病，但是以春季发病为最（最多），春为厥阴风木当令，在天为风，在脏为肝，胆主少阳，与肝互为表里，同气相求，故春季易患肝胆疾病而致四逆散证（这是他的解释，下边还有一段解释）。与此同时，将外感热病单独统计分析，结果 58 例当中，春夏发病各 15 例，秋冬各 14 例，冬春多为麻疹伤寒，夏秋多为暑热暑湿秋燥。这是由于四时主气之气太过，或疫疠病毒侵入人体郁而不达，形成四逆散证所致。故四逆散证具有一定的季节性，且多难治。”这是它的原文，咱们也简单地分析分析。这个地方用传统中医的理论对四逆散证做了一个典型的分析，虽然说文字不长，但是它非常经典也非常典型，思维方式上看，与现代医学的致病因子、传染、感染发病，没有什么质的区别。只是由于历史的原因，与病毒细菌之类的称谓有所不同而已。所以当与具体的临床数据结合的时候，就显现出了它的片面性。假设说上面这些文档，没有这些数据，你要这么看，咱们大家实际上都学过，你会觉得非常对，特别是学中医理论的人，都会觉得非常有道理，我学的就是这个嘛，而且感觉它这个天人合一嘛。这些数据是什么？这就是具体问题，这就是临床实践，你把它和临床数据揉到一块儿去，它本身就是解释临床实践的嘛，你把它跟临床实践结合到一块儿去，你就能清楚地看到这种思维的片面性。

比如这儿把四逆散证春季发病高的原因归结为“为厥阴风木当令，在天为风，在脏为肝，胆主少阳，与肝互为表里，同气相求……”解释了这么一大堆。所以他说春季易患肝胆疾病，如果春季发病的这 89 例可以做这样的解释的话，那么夏季发病的那 73 例又该作何解释？其他季节都按一样的道理，都该作何解释？另外，四逆散证当中还有很多不是肝胆疾病的，又该作何解释？一个医学的理论，依靠统计学上只有六个百分点不到的差距，就差这么一点的差距，就足以在这上面建立这么一大套的理论吗？严格地说，百分之几的这种差距，在统计学上就被称为是没有统计意义上的差别，可以视为没有差距。那么这套理论建筑在什么基础之上呢？另外，咱们实际上从四逆散治愈的现代疾病当中，有胃炎、肠炎、阑尾炎、头痛、脑萎缩、肋间神经痛、心脏病、肺病之类的，这又作何解释？如果这是五行生克的结果的话，那么真正肝胆疾病的那个，你又作何解释呢？为什么它又不生不克了呢？如果我们把视角再宽一些，春季发生四逆散证，你做这样的解释，那么春季发生其他的疾病，比如发生大承气汤证，你作何解释？所以说，这些东西不跟实践结合的时候，单纯地拿理论，中医里边有好多这样的人，你要他拿理论，他头头是道，你真让他看病，他就缩头了，就不行了，原因就在这地方。实际上这个我也不是刻意地要说中医怎么样怎么样，西医也一样，你就说只要是一换角度，它的那些科学理论简直就是谬误。

前天刚有报道，是中央电视台 10 套节目播的，说是厨房里面最脏的地方是哪？结果他在灶台上、油烟机上取样，化验分析，最终发现案板上是最脏的地方，细菌量非常高。既然结论有了，再跟实践一结合，你就会发现，他们所有说的那些卫生的要求，全都是一点用处都没有。为什么？因为没有一个人能够证明，因为案板的这种脏，致使人造成某种疾病，比如就这么统计一下，案板清洁得比较好的，和比较脏的，可以做个试验，做个假设：叫这一家人，这一年当中，一

天用个新案板，每一次一大堆人，一个人群。另外一个人群呢，一年当中就用这一个案板。你能不能找到用新案板的人比他们健康？恐怕他是最不健康的人群。那些专家们又说了，你的案板怎么样清洗，清洗完了要定期要晒、消毒等等，生熟还要分开等等的。那么你统计一下，能够做到的这一部分人群，比做不到的（做不到的太多了啊）人群，哪个人群健康？一下问题就变得非常清晰了。他这很多东西都是杞人忧天。其原因是什么？他就是片面的，他就是看到了，他只能看到那个细菌在哪个地方多少，他现在有仪器能看到。但是他恰恰不知道人体是怎样，通过吃了这个细菌以后，来提高自己的抵抗力的。

这更为重要的，是经方理论还清楚地表明，无论有无季节的影响，也无论不同季节之间发病率有多大变化，对于治疗，都丝毫没有影响。只要是现四逆散证，不管什么季节，都得用四逆散来治。你要从这个角度来看，传统中医理论对四逆散跟季节之间的关系的那种解释，就变得毫无意义了。我们进一步地来看看，你老说人家不行，那你有一套完整的体系么？我们再来看看经方医学是怎么认识四逆散证的？条文里面非常清楚：少阴病，其人或咳或悸或小便不利，或腹中痛，或泻利下重者，四逆散主之。从这个条文中可以清晰地看出来，这本身就是一个临床表现较为复杂，而且症状反应不够稳定这么一种疾病。尽管它这么不稳定，经方理论仍然是要通过患者患病以后的症状反应，来界定他是不是发生了四逆散证。这实际上就是经方医学通过长期的临床实践总结出来的一条，百试百验的治疗疾病的规律。没有明显的外因，而发生疾病的时候，要遵循这一原则。当有外因，造成疾病的时候，也要遵循这一原则。无论是何种原因，或者什么脏器、什么器官、什么组织，什么具体的部位发生了什么性质的病变，现什么方证，就要用什么方剂来治，都能取得理想的疗效。这就是经方医学与其他任何医学所不同的、并且高于其他任何医学的核心所在。

如果提高到理论层面的话，反倒是非常简单了。由上面这些分析，

我们就可知道，就四逆散证而言，经方理论认为，这个人体所以发生四逆散证，所以发生诸多的不稳定的症状，它就说明人体处在这种疾病状态下，不管有没有外界的影响，都得用四逆散来治。这虽然看起来没有多么花哨的道理可言，但是其中蕴含了很深的道。经方医学认为，人体之所以发生四逆散证，是因为人体处于一种内环境失衡的病态，而因为这种病态致使人体无法适应外界环境的变化，从而就可能发生各种各样的疾病，但是它具体表现呢，就是四逆散证。而这些患病后表现出来的症状，恰恰就是疾病的本质，或者说是疾病外在的一个投影。所以经方医学治疗任何疾病的目标，都是人体本身，是通过症状进行分析而得出具体为何种方证，为何种方剂的适应症。你只要能辨证准确，用相应的方剂治疗，它疗效就非常好。外界致病因素在经方理论当中，不过就是一个诱因而已。

我们用这种观点再来看看，我们刚刚读的四逆散证的临床统计资料与季节的关系，用经方理论来解释，这个方证的发生，主要是人体本身因为内环境失衡，而处于四逆散证的病理状态之下，一年四季什么时候都可以发生这种疾病。但是季节的变化，有时也会有一定的影响，不同的季节之间，发病率有轻微的偏差。但是无论什么季节发病，也无论发病率有什么变化，只要是现四逆散证，就要用这个方剂来治疗，这就是经方的解释。没有一点玄的、虚的东西。更重要的是什么？这种理解与临床数据是完全相吻合的，就是说经方理论和临床实践，是完全可以吻合的。这才是对事物本来面目的认识，这就是真理。

实际上就拿一个四逆散证来说，目前人类的知识根本没法把它解释得非常深入、非常具体。可是反过来说，疾病却不因为你人类认识得肤浅，技术的落后，或者说技术的不成熟，疾病就不发生了！你认识得深，它该得的也得，你认识得浅，它该得也得。所以说“治病”才是最重要的！现在表面上看，对人体都已经研究到基因的层面去了，纵然这样，实际治病的效果还非常差呀。大家去看一看胡老的那些医

案，大部分都是屡经中西医治疗治不了的，到他那儿一二副药，三四副药就好了，几天就好了。实际上这就是一条光明大道。如果这种观点被认同的话，大家想想，整个的人类医学研究的重点就应该有所转移，还得研究经方，研究中医这一套能够治病的医学的基础之上，你再去认识，再去进一步地认识，你先会了治病再说吧。

辨厥阴病^①

注：《宋本》作“辨厥阴病脉证并治第十二”。

厥阴之为病、气上撞心、消渴·心中疼热、饥而不欲食、
食则吐、吐蛔·下之、利不止、（326）

注：《宋本》此条文如下：

厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔，下之利不止。

胡希恕：今天咱们研究这个厥阴病。“厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔。下之，利不止。”这个厥阴病…也像少阴病似的，啊，就是津…津液不足，啊，血液也虚，这虚呀，这个津液虚他就是渴，啊，先渴，失水以自救嘛，那么…厉害了，甚至于消渴，消渴咱们都讲过了，他由于上边虚，那么下边这个…这个寒乘着上边这个虚呀，他气往上撞。那么他这是自己一个感觉证了“气上撞心”。那么上边人的这个胸中阳气，这个，阳气布于胸中了，它下边这个寒气往上，那么上边的热不得下布，所以他心中既一方面感觉气上冲撞心之疼，也感觉热，这个热不是发热那个热。“饥而不欲食”，这个厥阴病他是属于半表半里，不在胃了，所以胃没有毛病。他感觉饥，但是呢，它寒从下往上冲，虽饥而不能吃。食则……（音频 035 完）（音频 036 始）看他这个，上边又有虚热的情况，认为有实热，而误下之。那非使之陷入于里，而下利不止，因为他这

个阴虚证不能下。那么这一个…啊，仲景在每一篇都有个提纲啊，所谓提纲啊，他是概括这一篇说的。这个半表半里证啊，这个提纲都不好作。我们头前儿讲的那个阳性证就是这个少阳病，啊。那么少阳病这个提纲，他只是说“口苦，咽干，目眩”。但是那还能够说是，假设说半表半里这一个体部，有这个热，啊，盛于这个体部，它顺着这个腔间往上攻啊，他是，所以人这个孔窍之间就感觉这个有热候，啊，还差不多，还比较啊，啊。但这个，这个，这一句话也太概括了。那么有些内热的一种这个病，你像那种白虎汤证，他何尝不口苦咽干呐，那么那个是少阳病么？不是的。所以白虎汤证咱们讲过了，他是热结于里呀，他是阳明病啊，纯粹是阳明病的外证啊。那么所以说这个少阳病的提纲啊，也不够好的，啊。所以我们不坚持研究这个柴胡证啊，对这个少阳病，啊，这个提纲也不好。那么这为什么呢？就由于这个半表半里这个部位呀，半表半里指着这个胸腔、腹腔这么样一个…啊，这一个空间。这一个空间相当大，这一个空间呐，一切脏腑所在之地，啊，你像上边的心肺肝，脾胃肠，啊，以至于这个肾，啊，等等的，都是在这一个部位。所以这一个部位要是…病邪在这一个地方充斥，很容易诱发很多脏器，啊，失去正常，而反应一种证候。所以这一个地方这个病啊，是复杂多变。我们看看那小柴胡汤，啊，那个所主证就知道了。他虽然有，啊，“往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕”，那么底下有这些的或然见证，他就是或者波及到这个脏腑，啊，它发生这么一个情形；或者波及到那发生这么一种情形。所以它没有固定证候，很难为这一个，啊，为这这一种病啊，作一个概括的，简明的一种这个，啊，给它起一个特征。就是…你像表证他单纯呐，啊。你像“太阳病，脉浮，头项强痛而恶寒”。凡是太阳病，它都是以这一个作为基础的，不超出它。而且，凡是有这个情形，就是太阳病。唯独半表半里是不行的，啊，它这个病候复杂，不像那个表和里。那里你像那阳明病，啊，阳性病就是“胃家实”，这说的腑

证；那么他的外证呢？啊，就是但恶热，啊，不恶寒，啊，身汗，自汗出，这些好说，单纯。那么里呢？里就是虚寒嘛，就是咱们说腹满而呕，食不下，不能吃东西，食腹自痛，这一套。唯独半表半里，无论在阳，无论在阴，都不好，不好，不好有个概括的东西。那么这一个提纲啊，厥阴病可能发生这种情况。但是，不是说凡是厥阴病就能有这个情形。所以就个提纲很不好，啊。那么我们辨证的时候这个…他是六个类型啊，咱们只能够掌握四个类型，那两个类型啊，一个少阳病，一个厥阴病，只能够拿到意…意思它，啊，而不能够有什么具体的。那么怎么办呢？这辨证怎么办呢？这一个好办，好…好…这个讲完再说，我也要讲这…这个东西，啊。趁着这个机会，我略略说一说。这个辨证啊，这个表里易知啊。你像我方才所说的这个“表证”，啊，它是单纯，“表者”就是体表嘛，啊。咱们头前儿已经讲很多了，就是邪气交争于骨肉，啊，身体疼痛啊，发烧怕冷这个都是表证。可它有阴阳之分。阳者就是…咱们一开始就是“发热恶寒”嘛；那个少阴病就是没有热，而恶寒，其它同太阳病没有什么两样。“脉微细，但欲寐”，他是由于虚嘛，啊。他人困惫不堪，他一发生这个表证就这个样子。所以在表有这么两种，很好，很好辨的。也就是有临床上我们，啊，凡是以发汗方法解决的疾病，大概都是表证了。虽然他里头用药，啊，有时用这种这个，啊，攻伐性的；有一种的用一种亢奋性的，你像麻黄附子甘草汤，你像桂枝加附子，这都是加上亢奋药了，治阴证嘛，那都是少阴病。所以这个表证，很容易，啊，我们今…日常临床啊，也常见着。里证吧，刚才也说了，也很容易，他也不过阴阳两类吧。大便不通，啊，或者是热结于里这一套东西，就像我们说白虎汤证，发热而渴，不恶寒，是吧？但恶热，身上也出汗，啊，这是光热，热而不实；要实呢，大便不通了，啊，谵语烦乱都来了，这是阳明病。那么它的反面就是阴证，就是，啊，不能吃东西，“腹满而呕，食不下，自利益甚”，咱们所说的这种温中，啊，祛寒的这

一些药物，在太阴病咱们也讲了，啊，所谓四逆汤辈全是。这个表里知道了，除去表里，全是半表半里，我们在临床上就是啊，啊，除去这个表里了，一切的病全是半表半里。他人身上这个病位反应啊，就是…不是反应表，就是反应个里，否者就是反应在半表半里。那么半表半里这种证候要是阳性的，啊，或者热或者实的这么一种证象者，少阳病；反面儿，阴性的，啊，虚的，寒的，那就是厥阴病。所以我们辨证，啊，他这个书啊，这个六经的次序虽然与这个《内经》上的，啊，次序是一样，可是它这个有辨证的这么一种…一种意…意味。他先讲太阳，后讲阳明，他这…这一个实质上四五日、五六日这是传少阳，六七日、七八日，传阳明，我们头前儿也讲很多了。他为什么太阳之完，他应该讲少阳，他为什么讲阳明啊？他这个意思就有这个意思。表里易知，除去此而外，都少阳。变成少阳病这个，啊，提纲它不完备。他讲阴证，啊，表为阳，里为阴，他也先讲里，为之阴证的讲法了，所以他先讲太阴；然后讲表，少阴；除去里和表这种阴证，全是厥阴。他意思也是这个。所以在辨证上啊，没有什么妨碍的。可是研究这个书呢，我们对于这个少阳病的这个提纲，厥阴病的这个提纲，要活看，啊，这个不是一定。你像少阳病也是，凡是有内…有内热的这么一种，无论在胃肠之里，或者在胃肠之外，大概都口苦咽干，啊，那不一定就是少阳病。但是少阳病可能他是口苦咽干，是吧？所以他那个，啊，过于泛；这一个过于窄。这一个就是厥阴病有这一种情况的，啊，上边虚的厉害，下边寒的厉害，寒乘虚它往上来呀，感觉，啊，“气上撞心，心中疼热”，这是个自觉证。那么这个蛔，这个现在也…也值得研究了，值得考虑了。他是古人呐，大概人没有蛔虫的很少啊。他净吃生东西，是吧？尤其这个卫生上也差。就拿着这个仲景这个时候，汉的时候啊，当然不是这个，啊，啊…茹毛饮血了，可是但是这个，这个吃野菜的这个，啊，这个一般的习惯吧，还是多的，他不是都把它…啊，卫生条件也差，所以人人这个蛔虫大概都是

多的。普遍多，所以要是寒从下往上冲，啊，这个蛔，它是要受波及的，要吐蛔。如果人里头没有虫子，没有蛔虫，你再寒往上冲，他也不会吐蛔的。这是，啊，所以这一个，我们要，啊，也不要说是吐蛔虫，啊，这个就是厥阴病，也是不对的吧？啊。但是如果有虫子，有厥阴病这种情形，可能他要吐蛔。这一个就是注家啊，他就是，这么就是牵强附会，说是肝属木，厥阴病不是，啊，厥阴不是肝经吗？木风化，生虫子，这虫子现生的，那有这个事儿啊，啊，所以这都靠不住的事儿。所以咱们，啊，这个厥阴病，这一章也很成问题的。这是第一条。

李冠杰：下边开始学“厥阴篇”，篇名：“辨厥阴病”。在《宋本》里篇名是“辨厥阴病脉证并治第十二”。在经方理论里边，厥阴病就是半表半里证当中机能偏于沉衰的阴性疾病。如果我们把“厥阴篇”之前的那五大类疾病，那五篇中基本上都有这类的条文，把那些条文解释成经方篇的疾病类型加以鉴别，它为了诠释经方的病理，或是为了给本方证加以鉴别等等吧，为那些用处而加入的话，“厥阴篇”当中的这一类的条文则另有不同的原因。从内容上看，一类是非顶格排版的条文，作者明显有把厥阴病混同于厥逆证的情况，这个在学习过程中会详细地解释；另一类则是一部分与厥阴病无关的杂病的相关条文（比如说“呕利哕”这类的条文）；还有一部分是厥阴病的近似证，或者说是疑似后人从其他篇章中调整到这一篇里的一些条文。

这一篇这种特殊的内容结构，反映了这个书在《康平本》成书之前就已经处于一种零乱不堪的状态，印证了王叔和重新搜集整理的历史史实。明显地能看出来，很多地方怎么解释也不通，只能把放在其他地方都不太合适的内容挤在这儿了。

这条在《康平本》中是顶格排版的条文，在《宋本》里因为注解内容篡入正文，条文就变成：“厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔，下之利不止”。

咱们解读一下：

“厥阴之为病”，这是经方理论在《伤寒论》中论述疾病类型提纲条文的一种特有的论述句式，在六大类疾病中都有这样的论述。所谓的厥阴病在经方理论中就是指的阴性的半表半里证，也就是人体机能偏于沉衰的情况下而发生的半表半里证。

“气上撞心”，特别用了一个“撞”字，它的意思强调这应该也是一种气上冲，但是这个气上冲与奔豚证之类的或者其他类似的症状有所不同，它既不是气从少腹上冲胸咽那类的上冲，也没有说咽喉部位那类的感觉，而是心胸部位感觉到较为严重的自下而上的冲逆感，并伴有一定程度的热痛。对这个条文的理解我比较深刻，因为碰到过这样的病人，确实就是这样。她儿子说：“我看了我妈这样真太难受了”。她不是老是这个样子，我碰到的这个病人是每天吃了晚饭以后，晚上 10 点钟睡觉之前有一段时间特别难受。

在整个的经方理论中，有关此类论述的只有这个地方用了个“撞”字，即使是《金匱要略》里第十三篇消渴病当中，这个条文重出时“撞”字也被改掉了，被改成了“气上冲心”，可见条文当中的“撞”字有强调这个症状与其他症状不同的意思。另外这条在《金匱要略》“消渴小便不利淋病脉证并治第十三”重出的时候，虽然个别文字有更改，但是明显能够看出那条和这条是同一个条文，因为内容基本是一致的。这种重出的事实本身就可以说明一些很重要的问题。

第一个问题，条文出现在《金匱要略》中，这是后人从《伤寒论》摘录到《金匱要略》中的。有什么理由吗？至少有四个理由：第一，条文中论述的主要症状除了“消渴”之外，其他的症状与《金匱要略》中的“消渴病”根本就没有关系，而且这儿的“消渴”又恰恰不是原文的内容，原书的作者绝对不会把这样的条文加在消渴病里边。第二，从顶格条文论述风格来看，顶格条文的作者也绝不会将内容相同的条文重复的出现在同一本书里，因为《伤寒论》和《金匱要略》以前就

是同一本书，所以顶格条文的作者绝对不会做这样的事。第三，条文出现在消渴病中，主要的原因应该是旁注的“消渴”这一个症状的加入造成的。这也证明了它是后人调整的，加这个注的人做调整的可能性非常大。第四，条文是论述厥阴病的，“消渴”在这只是一个症状，把这个条文置于消渴病中作为题纲不合适。大家想想是不是从这点上看它也不应该出现在那个地方。

这就连带出第二个问题。如果上面分析成立的话，就可以进一步延伸出下边的一个结论：第一，把厥阴病提纲条文摘录为消渴病的提纲条文，说明这个作者对厥阴病的概念认识有误、认识不清。如果认识很清的话，他绝对不会把一个厥阴病的条文弄过去。他不把它当厥阴证当什么？把它当厥逆证。大家去看看后面条文，就是在这方面弄混了。第二，由此可知经方条文确实有被后世注家改动调整的情况。这个条文就是个例子，这一点也非常重要。为什么做这种分析？因为在不远的将来，我们学习《金匱要略》的时候会面临大量这样的情况，可是我们没有什么证据，现在还有《康平本》作参考，到那时候没有参考，就凭着我们的分析必须把这些东西都得摘出来，合适的、好的就正确地理解，不合适的、糟粕就一定要剔除。

旁注“消渴”指的是口渴欲饮水，而且饮水以后渴反不解的一种证候。先说一些后话，如果把乌梅丸证作为厥阴病的主方证的话，这是事实，乌梅丸证应该就是标准的厥阴病。乌梅丸证的临床统计资料中总共统计了 285 个医案，没有一例出现消渴症状，只有 34 例有口渴一症。但是口渴不等于消渴，口渴喝点水它能缓解了，那就不叫消渴了。而且在统计资料中这 34 例的发病率因为频率过低而没有被列入这个方证的主证，可见口渴这个症状本身就不是一个典型的症状，再加上它离“消渴”还有一段相当的距离呢。

旁注的作者必定是对厥阴病的概念认识不清，因此在这样的情况下所作的注解。因为得不到临床实践的支持，这个地方说一句简单的

话：把它划掉，不要相信。我们经过了一番分析以后，大家想想历史上凡学这一条的，恐怕没有人这么解释，或者说非常少。不是说咱们比别人高多少，只是我们充分地认识到了《康平本》的重要性，使我们能够解读到今天的这个样子。

“心中疼热”，是指心胸部不仅有疼痛感，同时还伴有热感的症状。这个症状和“气上撞心”是相互关联的。把这两个症状结合在一起，便是一种既有心胸部的上撞感又有疼痛感，同时还有热感的这么一种非常复杂的症状反应。这应该是厥阴病乌梅丸证其中的一个特征性的症状反应。虽然并不一定这个方证的每个患者都会出现这种证，但是一旦出现，用乌梅丸的可能性就比较大。这实际上是人体在整体机能偏于沉衰的情况下，既有上热又有下寒，也就是寒热错杂所形成的一种较为特殊的症状。

历史上都把它解读为寒，里寒上犯也好，上攻也好，其实到最后也说不清是什么。就是说上热下寒又处于阴证的时候，病重了有可能出现，实践证明就容易出现这类症状反应就行了。整个经方理论中，只有这一条用了“疼热”来论述这个症状。我们可以看出来，这儿的“气上撞心，心中疼热”在人体的疾病反应当中有一定的特殊性。

“饥而不欲食，食则吐”，它既是一种虽然有饥饿感，但是又不想吃东西，就是说肚子里边饿，嘴里边不要，而且吃了东西以后还常会出现呕吐的一种症状。这反映了人体处在寒热错杂状态下容易出现的一种症状。一方面半表半里有热，所以人体表现为某些亢奋的症状，有饿的感觉；另一方面里有寒，里又虚，强吃一点还会出现呕吐。

“吐蛔”是旁注内容，是作者对厥阴病在理解不够准确的情况下所作出的解释。这个提纲条文是乌梅丸证的主证或者说本证，是乌梅丸证的一种常见的症状。乌梅丸证的另两条在“厥阴篇”里有一个，在《金匱要略》里有一个，这两条基本上是一条，中间有点差别。那一个是专门来论述人体处在乌梅丸证的情况下同时又有蛔虫的时候，

会表现出一种什么样的典型的症状反应，实际上是这么一回事。学到乌梅丸证的时候，还会具体地再跟大家说。凡有这方面基础，你可以反复地去品味品味，实际上这个地方就是乌梅丸证的一个主要的症状。那个乌梅丸证真正的条文，是乌梅丸证同时又有蛔虫的时候的反应。以后具体解释的时候，还会跟大家把这个机理讲清楚。

“下之、利不止”，它跟太阴病条文当中的“若下之、必胸下结硬”属于相同类型的论述，就是重在强调这类疾病的治疗禁忌。厥阴病本身就是一个人体机能偏于沉衰，同时又里有虚寒的一种情况，这类的疾病没有应用下法的机会。大家看啊，太阴病里有论述，厥阴病里也有论述，那么阴性表证自然也是不可下的。后世总结的“阴证无下法”就是从这些条文的论述中总结出来的，这是符合经方理论精神的。

我们学习这个提纲条文应该弄清楚以下几个问题，这个提纲条文在厥阴病里了不得。因为厥阴病条文里跟厥阴病有直接关系的就这么一条。其他的都另有原因，所以咱们应该把它吃透了，对整个厥阴病就理解得比较深、比较透了。

第一个问题，这个条文是厥阴病的提纲条文，这是没有任何争议的。如果以这条为基础来整体地分析厥阴篇，就会发现厥阴篇顶格排版以外的条文跟“厥”有关的论述，实际上论述的都是“四肢厥逆”，不是厥阴病。因为后边还有“哕”吗，他把它放在最前边，而且特别是降两字格排版的条文，他把它的内容加在了乌梅丸证和提纲条文之间，没有别的意思，认为自己论述的就是厥阴病，但是这实际上是对厥阴病的误解。而厥阴篇当中的其他顶格条文内容都不是厥阴病，或者说只能算厥阴病的近似证。这种划分我们后边会说，古人的划分太粗略了，有一些东西似是而非。那么这就存在两种可能性，如果说书的原始样式就这个样子，我们只能理解成这是作者警示读者：这不是厥阴病，或者说只能算厥阴病的近似证，只能这么理解，这是第一个

问题。

第二个问题，在整个厥阴篇中只有乌梅丸证是真正的厥阴病。然而从这个方证条文中可以明显地看出很多疑点，咱们在学习那条的时候再详细地加以论述。但是有一点可以肯定，这个提纲条文论述的就是乌梅丸证的一种主要表现形式，其次才是用乌梅丸治疗蛔虫。这儿有一个很重要的资料，宋代庞安时写的《伤寒总病论》这本书里边，作者在解读这个条文的时候就把提纲条文之后直接写上了“乌梅丸主之”，因为他离汉代相对比较近，所以敢做这样的更正，恐怕他有一定的依据的，这是第二个问题。

第三个问题，从提纲条文的论述和乌梅丸的方药组成我们可以明显地看出来，厥阴病在病理辨证上属于典型的寒热错杂，而且寒症明显的又是偏于里证，它“治久利”嘛。在药上既有附子又有干姜，还有人参。按病位辨证应该属于半表半里的虚热证与里虚寒证合病。

在经方理论当中，这个疾病类型的界定是以症状为基础的，事实上阳性的半表半里证的方证中也有伴有里证的这种因素。比如小柴胡汤证就有里虚的因素存在，大柴胡汤证就有里实的因素存在，柴胡桂枝干姜汤证还有里虚寒的因素存在。所以说经方理论中疾病类型实际上都是由一个个方证群组成的。而且这六大类疾病的划分本身就非常得模糊，它是一个模糊的范畴。因为经方中的病理要素和疾病类型都是对方证的归纳和总结，所以说每一种类型的疾病中又都有典型的方证和非典型的方证之分。实际上这正是人体患病以后呈现出的复杂性的一种真实的反映。比如像桂枝汤证和桂枝加附子汤证，这典型的一个是阳性表虚证，一个是阴性表虚证。但这两个方证之间谁能给划出一个准确的分水岭出来？准确的区分点在什么地方？特别是到临床中就难以找到一个非常准确的固定点。实际上这是临床医生在临床中要把握的因素，书上不好说，甚至老师跟学生讲的时候也不太好讲，但是在临床中确确实实要面临这些问题。

从这我们就能看出来，经方理论中这六类疾病的分类方式，在当时的历史条件下对于经方理论的阐述，用这六类疾病作为一条线，叫六个大纲，把经方这套理论说清起到了非常重要的作用。但是也因为过于的笼统，而无法非常恰当的概括所有的方证。实际上这个问题还不仅仅在这个意义上，从历史解读来看，这种论述方式确实实是过于深奥了。因为解读了两千多年了还没有完全解读透，就容易让人造成误解。胡希恕先生晚年就在这方面做了大量地研究，但是最终还是因为没能取得满意的效果，他始终想把所有的方证分开，分成这六大类。从他的手稿来看做了大量的探索，但始终没得到一个满意的结果，最终也就是不了了之了，他在世的时候就一直没有发表。

事实上经方理论本意并没有想把所有的方证都纳入这六大类疾病里去，所以按照这种分类去分所有的方证，很难得到满意的结果。因为在六类疾病之外，还又存在了大量的所谓的杂病部分的内容。实际上，经方压根就没想用这六类疾病概括所有的疾病。正是基于上面的这些原因，我们在经过对经方理论深入地分析之后，在胡希恕经方理论思想的基础上，咱们整理出现在的经方病理辨证体系。实质上就是把经方理论中的六大类型疾病进一步细化。咱们把太阳病、阳明病、少阳病这些东西抹掉，把历代对经方各个不同角度理解总结出的病理要素打散了，再进行重新组合，像六经、八纲、气血津液，把它们打散了，然后再重新按着不同的性质组合起来，就成了我们现在的这种组合方式，本身就体现了事物的内在规律。

现在用病理辨证再来看乌梅丸证。乌梅丸证要是用六经来说，它属于厥阴病。但是厥阴病里边有里证，其实你说它厥阴病，怎么想也不是特别恰当，因为仅是厥阴病不能完全包括乌梅丸证的方证。如果用病理辩证它应该是个什么？乌梅丸证是厥阴病没错，再进一步地解释，还可以把它解释成阴性的半表半里证。大家看看方剂，再看看它的症状反应，这个方证中的寒热错杂、血虚、里虚寒等等这一类的特

征，实际上还并没有充分的、很恰当的概括到厥阴病里面去。但是如果用病理辨证来分析就非常得直截了当，这个方证的病理，咱就不管它是不是厥阴了，它就是一种阴性的半表半里的虚热证合并里虚寒证又合并血虚证。

这还不是问题的终结，随着研究的不断深入，我们认为它还有其他的病理要素的，随时可以加。病理辨证体系是个开放的体系，不像六经八纲那样。“八纲”再加上一个就成九纲了，那就不是了“八纲”了。病理辨证不是，如果认为在表、里、半表半里、水、血、气、阴阳、寒热、虚实这些要素之外还有其他的，没关系加上就是了。只要是有助于把所有的方证都能够恰当的概括到里面，符合事物的规律就行。这样最终就能形成一套可以恰如其分的反映出每一个方证的具体病理特征的这么一套体系。

厥阴中风、脉微浮、为欲愈、不浮为未愈、（327）

胡希恕：这个阴性病啊，啊，它一转阳，这病就要好的。“脉微”，啊，咱们头前儿也讲喽。脉微，啊，亡津液也，就是津液不足血液不足的脉微。虽然脉微而见浮，就是由阴出阳，啊，这病要好的，咱们后头讲啊，有的是，啊，净是这个。所以这个病一般呐，由这个阳陷入阴这是凶，啊。那么阴之甚以致于胃气衰败，那人就要能死亡吧，啊。如果病由阴转阳，就是生理恢复嘛，这个病一定是好的。他这一个也是，他虽然说个厥阴中风，他是概言之了，啊，当然是，啊，伤寒也是如此了，啊。他古人认他认为都是风寒两种病。那个病型呢，他乃…他从打太阳病他有 这么两种类型，在其它都是略略言之。

李冠杰：这个条文在《康平本》里是降两字格排版的，下面解读一下：

“厥阴中风”，应该理解为厥阴病的同时伴有某些表虚证的症状

反应。但整个厥阴篇中降两字格排版的条文论述的“厥阴病”大部分都是“厥逆证”，所以这个作者是否有以四肢厥逆为典型症状反应的意思，值得研究。

“脉微浮”，指脉虽然微弱但偏于浮象，这是以脉象来显示人体有阳性证的倾向。此处“厥阴”无论是指厥逆证还是厥阴病，都是不及的证候。作者的意思是如果此时脉已经开始现浮象，说明人体有向有余的方向转化的趋势，所以就“为欲愈”，病可能要好了。后边“不浮为未愈”是句纯属多余的话，一点用处都没有。

厥阴病、欲解时、从丑至卯上、（328）

胡希恕：这是一个照例文章，这个也靠不住的。他把十二个时辰呐，啊，他都分成这么，六经这个欲愈的时候啊，啊，他都…这是，这是根据这个运气五行的这个说法，这个靠不住的。这个从丑至卯，这是木旺的要。这是古人这么个看法。这个，啊，也不必强信，这都古人的一种看法，搁这块儿了。跟那个太阳病，啊，那个三阳病那都有嘛。

李冠杰：这类条文在六类疾病中都有，指厥阴病如果要好的话，在每天凌晨一点到上午七点这段时间内。不解释了，这类条文都不靠谱。

厥阴病、渴欲饮水者、少少与之愈、（329）

胡希恕：厥阴病他虚，他渴，渴了你就稍稍给点水，他欲饮水自救嘛，稍稍与之就好了。由这一段我们看着头前儿这个“消渴”，就成问题了，稍稍与饮既能够好，可见他不是“消渴”，啊。那么即便有“消渴”，也不是厥阴病普遍都存在的。那么这一段就是明明说出

来了，他这个“渴”，啊，不是那么样子渴，稍稍给点水就好了。这个厥阴病非常简略，就是这四条，你们看看这个，这…这篇就明白了，是以厥阴病作这个题首的，就这四条，啊，五条啊？啊，哎，四条，就这四条，都有厥阴病。从底下“诸四逆厥”以下，你们看看，一个没有厥阴病了，你看看这个本文都没有。那么根据这种，啊，题首也看出来，这个前后啊，不是论述一个主题。前四段全是论的厥阴病，以下呢，在这个《玉函》呐，啊，这个书啊，一套版，就是现在我们这个，啊，赵开美本儿也好啊，成无己那个本子也好，这都是宋以后，啊，他分开了《金匱要略》和这个《伤寒论》。这个《玉函》的那个编制大概与以前差不多，他是开始伤寒，一卷论伤寒嘛，中卷论的是杂病，那么最后他是出的这个方论，方子，就是…他那个书是那么编制，这个书有呀，咱们图书馆那都有。在这个《玉函》里头伤…关于论伤寒这一章，也是有这一个。可是到这个四条之后，他又一个题目。他是…这一个不是“辨厥阴病脉证并治”嘛，这四条。在这四条之后啊，又一个名字。他是“辨厥利呕哕病形脉证并治第十”，怎么出来个第十呢？他这个书啊，六经，他太阳篇就搁了三，啊，分成三篇，这个六经，从太阳到厥阴应该是八篇。他这个旧编制啊，他把“痉湿喝”这三篇，啊，这三个病也变成一篇，也搁到这一个，啊，六经之前了，共计是九篇；那么在这个九篇之后，他另有一篇，叫第十篇，什么呢？就是辨厥、利、呕、哕这四种病，厥就四肢厥逆那个厥；利自下利那个利；呕、哕病形脉 证并治第十”。那么我们要好好研究下边呢，的确是一点不错的，啊。他开始，啊，论治厥，然后就是论治这个利，下利，再后呕，再后是哕。可见那四种是杂病，啊，他附在这个后头。这一个，为什么他搁到这个厥阴病…弄到一起了呢？这是王叔和搞的，啊。那么王叔和那个人不是个平平常常的人，啊，对医学很有修养的人。他收集仲景杂论是不是啊？这个…这个…这个，啊仲景遗论，他编辑的时候啊，他一看呐，他厥阴病…六经病

后头都有证治，就是具体的证治了，啊，不是光有这么头前儿这么几句话就完了。你像太阳篇那更多了，那么少阳篇顶少，他还举出个柴胡汤啊，是吧？小柴胡汤啊。那么那个厥阴病没有，他一看后头啊，有些像是论厥阴的，尤其这个，他根据头前儿这个提纲，后边这个，啊，乌梅丸，很像说的是厥阴病，他就想这后头啊，一定就是厥阴病的一个续，在他这个，就是续着厥阴病而下的这个东西。所以在这么一个书啊，啊，他这个，不是一个，不是一…一起出来的东西呀，啊，他，他有一种编制啊，就把它编到厥阴病后头了。因为三阳三阴这个六经之后要是搁个杂病，他又想这这也是一个不伦不类的，啊，本来论的这个三阴三阳篇嘛，这是，论的是治疗伤寒嘛，那么搁个杂病，他认为这个…也不对，所以他就附在厥阴病之后。那么王叔和他一看呐，他知道不知道这是有问题呢？据我想他是知道的。他一看，他也知道这个东西呀，厥阴病呐，那是这可是热闹呢，你看后头这个方剂就知道了，啊，发汗吐下，应有尽有，哈！他一看也…也不对头。可是呢，他一种它的编辑呢，就是这一个本子呢，他把他合到一起；另外在《玉函》他原就隔开。他为什么呢？让后人研究。所以古人作书吧，他都留地步的，不是把这话说尽了。这是王叔和的意思。一方面他以为这个，这个第十这一篇是杂病，不应该在六经之后有这一个，啊，而且这里头有些似是论厥阴的，他附在这儿。他一看呐，有些是绝对不是厥阴病，他说这一个里头反正也是，总是有错误。但是原书上它是…啊，单独有那么一章嘛，哎，他又照着原书的这个排列，也…这个名字他就不搁厥阴了，他搁到《玉函》，所以《玉函》这个书是后发现的，这个让后人呐，研究讨论。我想王叔和当日啊，他不外乎这些的这个，啊，这些的想法，所以同是他编辑的这个书，有这么两种不同。那么后人对于这个研究呢，这一个书啊，先有的，在这个《玉函》这个书啊，这是后发现的，在宋的时候，啊，那跟那个《金匱要略》那一起发现的。所以经过成无己注伤寒，他到这个地…地方啊，他就胡

说八道了，他就认为都是厥阴病。所以大家也就是附然其说，把这个厥阴病说得呀，简直是一个，让人没法理解了，啊。所以它又时而为表，时而为里，时而为寒，时而为热，所以这一个，把这个厥阴病说成一个怪病吧。是讲这个厥阴篇的，到这儿都…都没法讲。我记着咱们这个杂志上还，还提过这个问题，但是没人把他搞明白还。其实呢，我们根据这个书的这个，啊，这个提法看，厥阴病只是这四段。底下这个还是《玉函》那个对。为什么要这么来呢？张仲景这个人他作书的时候，为什么在厥阴篇之末他附带这么一个杂病呢？这一个值得我们研究了。我们看看这个杂病净说的什么？这个厥、利、呕、哕全是与胃有关的一种证候。这个胃呀，啊，是生之本呐。所以我们头前儿也讲了胃气存则生，胃气绝那必死。所以治病啊，必须要顾虑这个胃气的。这一个陈…陈…陈修园先生，他，他不是看这一个看的，他是看那个各章他…他看出这一点，他说仲景用药都讲用甘药，甘以调之，就注重这个胃气。那么张仲景他在这个六…啊，六经讲完了，他特意拿出这一章给六经做总结，他说是千言万语呀，这个治病不能把胃治给坏了。这胃是个主要的一个关键。那么他就与这个胃有关系的厥，啊，利、呕、哕常见的病，把这个缓急生死，啊，他是搁到这个地方啊，啊，让…让给…给大家看一看，这是第一，就是为那个六经啊，啊，他讲完了，这是给六经病下个总结，这是一。第二个呢，他还有个用意，他这六经啊，不是专给伤寒预备的。这一个表里阴阳啊，是概括万病啊，是病不超出这一个表里，就是我们方才所说这个，这个病不在表、就在里、再不然就在半表半里，他不超出这一这一个范围，而这个病的反应呢，不是阳就是阴，也没有不阳不阴的这种病。所以这个六经啊，就是表里阴阳嘛，他是概括万病啊。辨一切病，这也都尽了。你看看，他就用伤…治伤寒的法子，在这一块儿治杂病，这个厥阴病后头这个杂病啊，就是这个。这就是正告医家，我们讲的是伤寒，《伤寒论》嘛，可是这个治疗是一致的，你看看这后头也是啊，

所用这个方子，无一不是在《伤寒论》里的方子。柴胡汤啊、白虎汤啊，等等的都是，啊，你看看这就是给这么一个见证，这是第二，啊。第三，还有个用意，仲景这个人呐，他是述而不作呀。所以这个晋皇甫谧他说得很清楚，他说仲景论广汤液为数十卷，用之多验嘛，啊。他这个，凡是这个六经的提纲啊，全是《汤液经》之旧，《汤液经》怎么有的，他也这么写的，你从打太阳篇到这个厥阴篇全是，有些照例的文章，你像我们方才所说这个，啊，“厥阴病欲解时，从丑至卯上”，这都是在《汤液经》亘古以来就有这么一种记载，所以仲景在这个原则上的东西呀，他都照旧写到这个地方。可是张仲景看他这个厥阴病这提纲，他也认为也不行。他没法子在这里头，啊，附一种方证的治疗，他没法子，与这个他不能够统一起来。可是在这个呢，虽然是杂病，这里头有些他论的厥阴，也视其方而已呀，你像这个乌梅丸、啊，当归四逆，这都是厥阴病的治疗，等我们讲到这儿，我们再细…细谈，啊。他就是补这个原来厥阴病这一个提纲的这个说法之不足。所以他有三种用意，所以他在这个六经之后，他有这么一个杂病篇。这是我的看法啊，在，在这个注家没有这个说法，啊，我看就这个样子，啊……（音频缺如）

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。解读一下：

对条文的内容要做具体分析：厥阴病是一种机能偏于沉衰且寒热错杂的阴性疾病，所以临床中有一部分患者会出现口渴一类的症状。如果确实属于厥阴病，即使表现为口渴，也没有少少喝点水就能好的可能性。如果说有，那相当一部分人就用不着吃乌梅丸了。另一个方面，如果这里论述的厥阴病是指“四肢厥逆”，那也不可能仅仅是用少少饮水的方式治愈。在经方理论中凡是少少与水就可以痊愈的病都属于主要疾病已经解除了，最后遗留了一点津液虚而造成的口渴，但是本条的论述里看不出有这一类的病理基础，所以不可取，不足为训。

另外条文内容跟第 326 条提纲条文中的旁注“消渴”一证也存在

矛盾，这里论述的“厥阴病，渴欲饮水者，少少与之愈”就不应该存在“消渴”的情况。这种情况最大的可能性是这个条文和那个注解是出自两个不同的作者之手。

诸四逆厥者、不可下之、虚家亦然、（330）

胡希恕：“诸四逆厥”，这个四肢厥冷啊，啊，这个为证也挺反…反复啊，不是一种。无论那一种，凡是四肢厥冷，虚多而实少啊，啊。“不可下之”，是遇着这一个，大概都虚寒的多，不要吃泻药。“虚家亦然”，他拿…他怕你误会，这个厥逆也有实证，很少，啊。那么他拿这个虚家作陪，他说，我说这个“厥逆不可下”呀，就像这个虚，啊，虚家不可下，是一样的，一致的，啊。说遇着这个诸厥呀，要好看，不是随便要吃泻药的，原则上说是不能吃泻药。有些特殊，啊，那又当别论了。你看这一个，他一个也不提厥阴病了，啊。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。解读一下：

“诸四逆厥者”，理解为不论什么类型的疾病，凡是出现四肢厥逆的情况都包括了。一般情况下四肢厥逆是里虚寒证的证候，所以这个作者就说是“不可下”的。

“虚家亦然”，指长期患虚证的人。特别是里虚证，在这类情况下用下法的机会比较少。

这些降两字格的条文都没法细品，“虚家”在临床中还真有表现为大承气汤证的，那就得用大承气汤治。胡老就有这种医案，有些上年纪的人是真正的大承气汤证也得治，所以这里只能说在大多数情况下，这是其一。另外“四逆厥者”仔细看，“四逆”是四肢厥冷了，本身就已经“厥”了，那这个“厥”是什么意思？这里能品出这个作者对厥阴证、厥阴病几个概念比较混乱。

伤寒先厥、后发热而利者、必自止、见厥复利、（331）

胡希恕：这个伤寒冲着一般说的了，啊，就是指着太阳伤寒这一…这一类的证候了，这没指着厥阴呐。“先厥而下利”，这个厥怎么与胃有关系呀？咱们头前儿讲很多了，这个谷气不达到于四末…四肢，四肢厥冷，啊。四末就是手脚了。这个在《内经》上有，所以我们饮食入胃，啊，经过血管吸收，说脾为行津液嘛。这一种就是谷气了。拿着现在的话说，就是食物的，啊，一种营养东西。那么血管吸收了，这个古人就叫做精气。精气者，就是养人的精真之气，很…很宝贵，这个东西。可是这个脾给他行津液，脾主四肢，达到了，啊，所以这个，到哪儿哪就能活动了，这古人这么个看法了，说到了手，手能握，到于足，足能行；不到，不到就不行了。不到就厥，四肢厥冷。就是胃气虚，而不能布气，津液不达于四末，就是血液了，啊，那就要厥。厥，就胃虚呀，他就要下利。先厥，啊，后来这胃恢复，发热，下利也必自止。他这一句话呀，伤寒，先厥后发热，而利者是承上句说的，承这个厥说的，那么到发热，厥去了，这个利也必自止的。那么再见厥，又不发热了，四肢又冷了，那还要利。那么这一个说明就是“厥、利与热往复”，啊。那么有几天厥而下利，过几天，啊，有热下利又止，这么一个往复。所以他这个厥利往复，这个说法儿，颇似半表半里证，颇似说厥阴。我们头前儿讲少阳篇的时候，有个“往来寒热”呀，是吧？一阵冷一阵热，那个仲景他有注解，他说是邪正交争，往来寒热呀。邪与正争，才发现那个往来寒热；那么这一个呢，也是邪与正争，那么胃一时恢复，啊，胃气强，发…发热，那个利就好了；那么邪胜了，胃气衰，他又厥而下利。这不也是一个…啊，不过这一个它是阴证，这个“往复”不是“往来寒热”了，也不是当天，他不定是几天？后头慢慢有，啊。他，时而厥利；时而厥利没有了，发热。这一个说的是厥阴，虽然论的这是厥，专讲的是厥，但他这个条文里

头啊，有些就属于厥阴的。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。解读一下：

条文的大致意思是：患伤寒病以后先出现四肢厥逆的情况，之后又出现发热的情况，同时又伴有下利的症状，这种情况下该条文的作者认为患者的下利必然会自行停止，如果停止了以后再出现厥逆的，那患者还会出现下利的症状。其实也不外是说厥逆是里虚寒证的证候，所以便会出现这一类的症状表现。

伤寒始发热六日、厥反九日而利、凡厥利者、当不能食、今反能食者、恐为除中、食以索饼、不发热者、知胃气尚在、必愈、恐暴热来出而复去也、后三日脉之、其热续在者、□^①期之旦日夜半愈、所以然者、本发热六日、厥反九日、复发热三日、并六日^②、亦为九日、与厥阴相应^③、故期之旦日夜半愈、后三日脉之而脉数、其热不罢者、此为热气有余、必发痈脓也、（332）

注：

1. 《宋本》无此缺字符号。
2. “并六日”《宋本》作“并前六日”。
3. “与厥阴相应”《宋本》作“与厥相应”。

胡希恕：他这个条文有不好懂的地方。“伤寒始发热六日，厥反九日而利者”，咱们不必都念了，我念一句讲一点吧。这个伤寒呐，开始发热，啊，发热六日，那么这个厥呢？反而六日过又加上三天，九日。一到厥他就要下利，跟头前儿他接着，他承上文说的。他厥的时候下利，热的时候下利就没了。可是呢，他这个厥和这个热呀，这个不相应，发热只是到六天，可是厥呢？继续到九天，厥和下利。这

一个现象不怎么好，是吧？这就是说是这个，啊，阳退阴进呐，这个正邪这个斗争啊，这个纷争啊，啊，正不胜邪的样子。“凡厥利者”这个厥利呀，这是一个阴寒的一种，啊、虚衰的证候啊。这都胃虚的很，你看到这个时候，他提出这个胃，啊，“当不能食”，这个厥利的进退呀，正说明这个，啊，阴阳，啊，进退一个生死之机呀，可是归终到那儿呢？归终到胃气。所以在这儿他点出了。这个厥利这是个虚，虚而有寒，“当不能食”。如果这个病人他反能吃，这一个有可能是除中。什么叫做除中啊？就是没有胃气了。“恐为除中”，中者就指着这个，啊，咱们中气那个中了，就是指着胃。胃气没有了，胃气没有这个人非死不可，啊。那么他这一个要试验一下子，“食以索饼”，这个“索饼”说法也不一呀，有的说这个索，就是素，就是平常吃这个饼；有的说这个索，索然无味嘛，是吧？没有肉，没有馅儿，没有馅儿的饼，啊。都行，就是平时吃的这种饼，试验一次，试验一下。要如果吃这个饼“不发热者”，这没有什么大问题，这个胃气呀，还存在，没除中，啊，这个吃是好的，这个胃气恢复了，这个病不怕，啊。“必愈”这是一个倒插笔，啊。他说是啊，这个厥利和热往复这种病，在这个厥利这个期间，不应该吃东西，啊，应该不能吃，不是一点也不能吃啊，总之食欲他吃，吃不多的，啊。如果这个人嗜食，这个与这个病情相反呐！这个大夫就要注意，这不是好现象，恐怕有除中。那么可以有这一种试验，啊，食之以索饼，如果要是一下子发高烧，那就坏了。不紧，不紧那就不要紧，这个病可以愈。“恐暴热来出而复去也”，就怕这样子。啊，一给他，咱们…我们家乡有这么一句话，叫吃一炉食嘛。啊，爆吃一顿，完了就完了。就是伶仃吃完了，发一顿暴热，然后暴热一去，人也死了，啊，这叫除中。要是不发呀，那没问题的，这是倒插笔，他就是专为这个厥利期间能食者，有这么一种试验是否除中之法，底下他接着说呀，啊。后三日脉之，这是个“三日”，啊，“后日脉之”这，应该添个“三”。

他这个接着这一个“厥反九日而利”言之。这个，缘起他发…啊，发热六天，他这以前经过就是啊，啊。然后厥，厥他不是六天到九天了，第十天怎么？第十天发热了，他九天嘛。人家说得很明白嘛。他这个暗中说在这十天就发热了，发热到第三天的时候，和那个，那六天，也九天了嘛，那时候你摸，切其脉，啊，“其热续在者”，这个人还发热，这不紧了，啊。这一个不是阴进阳退的样子，这正相当了。虽然连续他九天厥利，但是九天厥利之后么，他又发三天烧，那么发三天热，跟以前那六天，也九天嘛。所以“期之旦日夜半愈”，这个“旦日”就是“平旦”，就是，啊，今天晚上说吧，“明天早晨”。“明天早晨”一过半夜就是明天早晨呐，啊。所以 这个病啊，一看起来呀，可以期望他，啊，在这个旦日夜半，这个病可以好的，有这么一种希望。为什么呢？他底下解释了，所以然者，本发热六日，他开始发热六日，这个厥反九日，后连续发热三日，并前也是六日，加到一起也是九天，那么这一个厥利和发热相应，啊，恰好，如果病该好了，到第十天他也不厥了，也不热了，这个病准好。所以“期之 旦日夜半愈”。那么假若后三日，我们诊察的时候，也没厥逆，可是人也没好，怎么个事情啊？太过了，啊，“而脉数，其热不罢者”，这也不是要好的样子，此为热气有余，啊。就是这个，啊，过于亢奋了，啊。“必发痈脓也”，这个热久不愈了，啊。已经满九天，和那个六天，以后他老热起来了，这一个在这个医书上有了。所以，热久不愈者，必发恶疮啊。他这个老在这个体表发热，啊，在这个，啊，肌肉筋骨之间，这个营血受伤一定要发痈脓的。这是指着外边生疮。这一个，我们讲那个《金匱要略》啊，啊，在这黄汗那一篇上就有，啊，久者，必生恶疮。热久不除嘛。那么这一段呐，他是这个意思，啊。他说这个厥和热，这是一个正邪交争一种情况，那么如果厥几天，热几天，过后了，如果也不厥不热了，这个病可期望在这个厥、热相应的这个时间好的。好大概都在这个时候吧。如果不好，热有余，那也不行，

那就要变成其它的病了，但是也不关乎阴证了，不关乎虚寒了，那么这一个，他又举这么个例子。在这个厥利这个阶段，人要能吃也不是个好现象，这一个有除中之说。可以示以… 啊，这个平时吃的饼，如果吃了饼他也不发烧也不怎么的，这说明这个胃气很好，这个病是准好的，啊。就怕胃气败，暴热来，同时就去了，就没有热了，还照旧厥利，那非死不可，那就叫除中。这个除中啊，也不是一定准得这个病的自己进展造成的，也有人人为的。底下这一段就是，这大夫给人治就能治出这个来，所以你不要碍胃呢，所以他这个宗旨在这一…这一句更可以看得清楚。

李冠杰：这条是降两字格排版的条文。第一个差别，在《宋本》里没有《康平本》里的缺字符；第二个差别，“病六日”在《宋本》里是“病前六日”，更明确一些；第三个差别，“与厥阴相应”《宋本》里是“与厥相应”，没有“阴”字。下边解读一下：

这条在《伤寒论》中属于少有的文字冗长的段落，条文论述的内容在临床中没有典型性和代表性，甚至其理论观点有机械套用某种模式的倾向，与经方理论精神是相悖的，所以对这一类的条文就只做字面上的解读。

做个直译：患伤寒后出现发热并且持续六天时间，而后便出现持续九天的厥逆症状，并且伴有下列。一般情况厥逆并伴有下列症状的都应该食欲不好；但是如果刻下患者反而出现食欲较好的情况，这可能是“除中”（后边条文有解释，是一种重病）；如果吃东西之后并没有出现发热的症状，说明胃肠功能基本正常，那则有痊愈的可能；不好的情况是吃了东西以后出现突发性高热，并且还会自行退去（这里暗指“除中”）。如果三天后再诊其脉仍然呈现热象的，则可望当天半夜能够自愈。这是由于本来发热六天，而厥逆反而发作了九天，之后又出现了发热三天，与厥逆之前的发热合并计算，发热总共也为九天，与厥逆发作的时间相等，所以便有半月痊愈的可能。如果三天

后再诊脉，不单脉现数象且发热也不能自行停止的，这是患者热证太重，有可能发生痈脓的变证。

这条没必要深解了，因为值得注意的就是条文中的“本发热六日，厥反九日，复发热三日，并前六日，亦为九日，与厥阴相应”，这就是厥逆证。此处明明白白就是这个事，虽然在《宋本》里把“阴”字去掉了，但从其他条文的论述看，这的“厥阴”也不是别人抄的时候误加了一个“阴”字，而是当初这个作者确实写的就是“厥阴”。这显然与经方理论中的厥阴病不同，这是一种错误的理解。所以降两字格排版的条文所有有关厥阴病的论述都要将这个因素考虑在内，都有这方面的倾向。而且从改动来看《康平本》是这个样子，到了《宋本》把“阴”字去掉了，说明该作者对厥阴病的认识模糊，自己也拿不准。如果进一步延伸，经方理论中的六类疾病是一个有机的整体，假如对厥阴病的认识有错误，那么对其他类型疾病的认识也必然会存在一定的偏差。实际上对降两字格排版的条文都应该客观的分析，对的就接受，不对的就应该澄清。

实际上这还是比较浅层的说法，我们学中医都不是一天两天了，去观察一下中医界的一个现象，凡是对《内经》理论学得比较好、比较热衷的人在学经方的时候最感兴趣，体悟最深，最喜欢拿着说事的几乎都是降两字格的条文。记得曾经有个人写了挺长的一篇文章，他对经方理论的理解说来说去列举的竟全是降两字格排版的条文，后来我就给他发了一个帖，说你用的这些条文在《康平本》里是一个什么样的状态，后来再没见过这个人写过其它文章了。

伤寒脉迟六七日、而反与黄芩汤、彻其热、脉迟为寒、
今与黄芩汤、复除其热、腹中应冷、当不能食、今反能食、
此名除中、必死、（333）

胡希恕：“伤寒脉迟，六七日”，这个六七日都是这个病啊，自表传里的时候，五六日传少阳，六七日他要传阳明，要从表传里。这一个大周期是这样子，它这个日子啊，你翻…翻这个前后书就可以看得出来的。但是“脉迟”，这个传里呀，里头也必寒，迟者为寒嘛。这一句话呀，与头前儿有一段书很相…相似的。头前儿咱们讲，这个他缘起说的是伤寒呐，没有汗的太阳伤寒，脉浮而迟，表热里寒，四逆汤主之。头前儿咱们有呀，在太阳篇里头，他讲过。这一句话呀就是由那一句话来的。虽然太阳伤寒是表证，脉浮但是而迟，里有寒。六七日又要传里的时候，你别等他腹痛下利，真正变成，啊，太阴病了，虽然有表，也不要管表，要舍表救里呀，应该用四逆汤。那么这个大夫遇着个糊涂大夫，“而反与黄芩汤彻其热”。黄芩汤这是一个，啊，去热的药了，这个头前儿咱们也讲过了，啊。黄芩、芍药、甘草、生姜那个方剂了。反与黄芩汤而彻其热。应该温里嘛，用四逆汤嘛。脉迟为寒，今反与黄芩汤，复彻其热，腹中应冷，当不能食；今反能食，此名除中，必死。这是大夫给治的，那么黄…吃黄芩汤又彻其热，彻其热了，这胃中更冷了，这里头啊，啊。那他绝对不能吃东西了，那么现在他还反能够吃东西，这一个也不用试验了，准是除中，必死。这一段呐，正是他这一个，搁这一个杂病，啊，与胃有关系。这种杂病，而为六经宗旨的一个最大的眼目。就这治病你不能把胃气给治没了，治没非死不可。这个病本来不算个什么嘛。伤寒脉浮而迟而已呀，啊，你赶紧救里呀。救里救什么？救胃呀。你不但不救，而反吃黄芩汤再彻其热，这倒行逆施啊。所以这个当大夫这东西，啊，你不能不注重胃，所以咱们在临床上也是啊，尤其是慢性病，你要把这胃给治坏了，这个人呐，非交代不可，他不会恢复的。所以我们遇着这个慢性病，真是胃不好，你非得想法调理这个胃，让他恢复胃气不可。那么这是他的一个最主要的一个最大的眼目，在这儿特别提出来。他在厥利里头他就特别告诉你这是关乎胃气。所以除中者死，啊。

这个厥利他也归到胃气为主，在这儿又突然提出来这个治疗，所以他给六经作总结这是对的，啊。这是我的看法，啊，我也根据这个书呀，我也不是随便想。他这很清楚，他在这儿特别提出来这是一个，啊，有这么一种误治，就能把人治成除中，这个意思不是昭然若揭嘛。

李冠杰：这条在《康平本》中是降两字格排版的条文。

“伤寒脉迟六七日”，指患伤寒病后同时又偏于里寒，且这种情况已经迁延多日了，说明里寒证比较重。按照经方治疗原则此时应先温里后解表，但此处是“而反与黄芩汤、彻其热”。经方中黄芩汤有两首：一首出自《伤寒论》第 172 条，方剂由黄芩、芍药、甘草、大枣四味药组成；另一首出自《金匱要略》，但是在《金匱要略》里的是一个复方，所以它绝对不会是这个作者论述的范畴。因此这里指的应该是第 172 条的黄芩汤。黄芩汤是个偏寒的方剂，用在此处方与证不相应，属于误治。

“脉迟为寒、今与黄芩汤、复除其热”，这是对前文的解释和重复，没有什么深意。

“腹中应冷、当不能食”，本来就有里寒证，如果再用寒性方剂，必然会使里寒进一步加重而影响胃肠功能。应当注意该条文中犯了一个低级错误，但是我曾经就有这样的体会：一个特殊的原因，因为外界因素自己着凉了，处于一种里寒的状态。前一天还在吃半夏泻心汤，吃了挺舒服，结果因为着凉了，吃了早饭以后再喝半夏泻心汤就特别难受，按理说半夏泻心汤里还有些温药，且都是些养胃的药。后来喝吴茱萸汤就好了。所以这个不是虚言，在临床中寒热用反了以后，确实马上就出现不良反应。

“今反能食、此名除中、必死”，这是该条文论述的重点。第一，阐述了在里寒证的情况下，误施寒性剂以后出现的一种反常情况。作者对这种情况进行了特殊的命名，为“除中”；第二，阐明了这一类情况的严重性——“必死”，虽然不一定准死，但是情况比较严重，

因为本来这个病就迁延很多天了。该条文论述的应该是阳性表证与里寒证合并的情况，或者也可能是阴性表证。但无论如何在有里寒证的情况下，误施以寒性方剂，都能产生一些不良后果。但是这个病与厥阴病无关，不知为什么会加在这儿。

伤寒先厥后发热、下利必自止、而反汗出、咽中痛者、其喉为痹、发热无汗、而利必自止、若不止必便脓血、便脓血者、其喉不痹、（334）

胡希恕：这个也承着，啊，那个厥热…厥利和热往复那个说的，他说这个伤寒先厥，四肢厥冷，后来发热，啊，就是阴退，啊，阳进了。原来他有下利呀，一并必自止，这跟头前儿这一样，啊。先厥的时候他下利，后来发热了，这个下…这个…这个下利必自止。他底下分两段说，有个不同的情形，啊。“而反汗出”，要下利必自止，没有其它的关系了，这病就好喽，啊。可是呢，这个阳进得太…太厉害了，就是热有余了。热有余有这么两方面。一个它亢于上，而反汗出，嗓子疼，啊，这个热往上亢；所以这个，这个证的变化呀，他随人体质各个的不同了，啊，它或者亢于上，或者它是迫于下。他先就亢于上说的。那么要是反汗出，这亡津液了，再有热，他嗓子一定疼。咱们“少阴病咽中痛”不是咱们也讲过了嘛，他津液本虚，啊，那么再有热，他非嗓子疼不可。这个嗓子疼啊古人叫喉痹，“其喉为痹”，这是个病名，喉痹。这是第一种。第二种，发热无汗而利必自止。他这个…也接着前边，他说“伤寒先厥后发热”，他不是“反汗出”，他是一个“发热无汗”，发热无汗但是以前这个下利也一定止。假设不止呢？不止这热有余了，“必便脓血”。这一个他是不往上亢往下迫，啊。便脓血，他是热往下，啊，这个热伤阴分他也便脓血嘛，啊。可这一个也不是阴证了，也变成阳证了。这一个当然是我们可以用，

啊，治痢疾的法子治疗了。热下迫而不上炎，所以他咽不痛。这都是就这个病的现状而预后，啊，预料他后来的一种情况。他本来是先厥而下利，后来发热而利止，那么这一个变化呢有这么两种不同。如果热有余他这病也不好，不好热有余看有两种：一种是汗出咽中痛，这是说说这个热往上，亢于上，那其喉为…为痹，这是一种；另一种呢，发热无汗，可是下利也必好，那是准的，他热有余嘛，啊。那么假设说是，发热无汗利止以后也不发热了，啊，身凉体和那就好了病了；要是不好，不好这热有余，那不是阴证，啊。由阴寒转为阳性病了。这个阳性病，如果这个热，啊。它自里以下迫，那就要便痢疾，啊，便脓血那一种热痢，可是，一便脓血他不会嗓子痛的。这一个与那一个正相反，那个是往上亢，这个是往下迫。这是根据现在的病，啊，本来他是厥利往复这么一种情况，那么到时候，他不下利了，也不，四肢也不厥冷了，但是这个病要是不好，热有余的话，有这么两种，啊，预后。那么这一个啊，都像论的这个厥阴，这个厥热往复啊，这个很像，啊。那么但是后头这个辨证呢，由阴出阳了，这个病都是好现象，虽然热有余，都不要紧的，那都不属于厥阴了。

李冠杰：这条跟绕口令差不多，也是降两字格排版的条文。下面解读一下：

“伤寒先厥后发热，下利必自止”，按照该条文作者的观点，是指人体由机能低下的状态转为偏于亢奋的状态。实际上这类情况未必准是往阳性证、往亢奋状态转，阴性证也有发热的情况。所以该条文作者的观点是：如果本来有虚寒证，发热后由虚寒证引起的下利就会自行停止，并且还可能出现“汗出、咽中痛”这类热亢于上的症状。当然这里就有内在联系了，“发热”再和“汗出、咽中痛”这类热证结合在一块儿，这种虚寒性下利要自愈就有一些依据了。

“发热无汗，而利必自止”，如果出现发热但是没有汗，在这种情况下仍可能出现下利自止的情况；但此时如果下利不能自止，则有

可能会出现“便脓血”的症状，而且凡是出现“便脓血”的多不会发生“喉痹”。这类条文既没有临床代表性，且理论观点缺乏客观性，但毕竟论述的都是临床上的东西，我们就仅作参考。

伤寒二三日至四五日^①、厥者、必发热、前热者、后必厥、厥深者、热亦深、厥微者、热亦微、厥应下之、而反发汗者、必口伤烂赤、（335）

注：“伤寒二三日至四五日”《宋本》作“伤寒一二日至四五日”。

胡希恕：所以他论的是诸厥嘛。不净说的有关厥阴这种厥，啊，厥利，不是的。有没有一种厥属于热的？他说伤寒一二日，开始一二日，就是，啊，太阳伤寒那一种情况了，那么到这个四五天这个阶段，“而厥者”，四肢厥冷，啊。那么样儿呢，他伶仃厥以前他一定是发热的，“必发热”，这个“必发热”就说的一二日那个时候绝对发热，而且“前热者后必厥”，这因为前边儿有发热，后边儿才有这个厥逆，这都说的这个热厥了。“厥深者，热亦深”，现在四肢厥冷得厉害，那么以前发热也是厉害；否则，现在这个厥较比微，以前那个热也一定是微。这个他是，啊，像白虎汤证也这样子，白虎汤证有四肢厥冷的。这一阵儿热为什么？我们讲那个胃，啊，所以血液、津液不达于四末者厥冷。这个热怎么能也有这个情形呢？也能的。这个热，真正要是，咱们讲这热伤津液么，啊，这是一；二一样这个热气要是这个，壅满到这个，啊，这个里呀，也能够阻碍气血的，啊，气血的通畅的。他这个讲的实热更是了，他说讲下。你像咱们讲那个，啊…瓜蒂散，邪实于胸中，他四肢厥冷，你非吐不可。把这个“实”，它在那里头不阻碍这个大气了，啊，你这个四肢血才能到呢，他一个…一个样儿，实证也能造成这种情况。这一种厥呀，“应该下之”啊，你不能用温性药来发汗来，“而反发汗”，一定要是口伤烂赤的，啊，

你再伤失他的津液，他指着伤寒来说的，这不是论的厥阴病，啊。这个伤寒是病在表嘛，病在表，啊，一阵儿，这热的时候相当的凶，就是四肢冷，这个冷纯粹实热的关系，这个发汗都不行。像我们头前讲那一个，说吃四逆汤，那更了不得了，啊，那非药死不可，是吧？所以这个他讲这个“诸厥”嘛，有一种热厥也不得不知啊。这一个好说，你像这个 伤寒病，啊，这个太阳伤寒，一开始，高烧。他也容易致厥，烧得厉害厥就深，烧得轻者，厥较比微。总而言之，这个厥，还是热。你即刻解表，咱们现在说治温病的法子，也用辛凉解表了，你不能用辛温来发汗，啊。那么伤失体液更助热，那一定是口伤烂赤，啊，这是轻之说了。这还说是，啊，攻表没温里呀，要是大温里更了不得了，那就出了大乱子了，这就所谓……（音频 036 完）

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。条文中的“伤寒二三日至四五日”在《宋本》里改成“伤寒一二日至四五日”。虽然这个改动对条文的论述影响不大，但是可以佐证一个问题，就是王叔和二次整理过这本书，这也是依据之一。如果不是他自己改的话，别人完全没有必要作这种改动，只有作者本人第二次看的时候觉得可以再把日期提前一点，就作了一点改动。下边解读一下：

条文论述的重点就是热厥。“伤寒二三日至四五日”是指患了热厥多日不解，而且此时按作者的观点可能出现下边的情况：如果初起发生厥逆的，则之后会出现发热；如果初起发热的，假如病不得愈，其后也有可能出现厥逆。并且此类厥逆有以下特点，就是“厥深者、热亦深、厥微者、热亦微”，这是热厥的一个特征性的症状反应。后世在临床中确实有这一类的，虽然不这样机械化，但是有这样的规律存在。比如白虎汤证热厉害厥逆也很厉害，有这样的情况。

“厥应下之”在这儿应该理解成什么？这个“下之”决不能理解成用泻下的方法治疗。我们给打个圆场：这个地方应该理解成这类的热厥应该用清热的办法治疗。如果发汗就是误治，就有可能出现“口

伤烂赤”这类不良的后果。

伤寒病、厥五日、热亦五日、设六日、当复厥、不厥者自愈、厥终不过五日、以热五日、故知自愈、（336）

胡希恕：（音频 037 始）……厥终不过五日么，六日他不厥了，啊，所以知道他是必愈的。但这个语意也有含蓄呀，上边他讲了，如果热有余呢，那又当别论了，是吧？但是这一个，啊，这一种寒厥，这一种虚寒之厥这肯定这是要好的了。

李冠杰：这条在《康平本》中是降两字格排版的条文。下边做个直译：

患伤寒病后，如果厥逆五天之后又出现发热的，那发热也会是五天。当发热到第六天的时候，应该再度出现厥逆的症状。如果不出现厥逆，就可自愈，即使是再度出现厥逆，也不会超过五天，因为之前发热为五天，所以便可知厥逆也不会超过五天。

该条文把人体的疾病反应机械化、模式化，且不论临床中有没有这样的现象，仅是机械解读人体方式就已经背离了经方医学的精神实质，所以这种条文无任何可取之处。

凡厥者、阴阳气不相顺接、便为厥、（注）厥者·手足厥冷者是

① • （337）

注：“手足厥冷者是”《宋本》作“手足逆冷者是也”。

胡希恕：他说“凡厥者”，啊，为什么厥呢？他在解释这个，这个是专解释这个。就是阴阳气不相顺接呀。这个阴阳气指的什么？据我们现在来观察呀，是指着静脉、动脉这个血。古人也是这个看法，啊。古人说是这个，这个血管啊，这个六经啊，这古人不叫血管了，

叫经络，啊。他都…都集中手足。所以手六经、足六经嘛，有阴有阳。咱们所说的那个阳啊，经脉呀，大概就是指动脉，阴（就指的静脉，啊。这个阴阳气不相顺接就指着这两个东西。这个动脉的末梢，哎，他就要，啊，这个静脉的末梢他就要吸收，他这个，他这个尖端上啊，都在这个四肢，这是…这是合乎现在这个解剖生理，这都。如果他们出了，啊，血液供足不到了，他这两个衔接也就断了，所以他要厥，他说阴阳气不相顺接，便为厥。那么厥是什么样儿呢？就是手足逆冷。逆冷者由外往里，啊，先由手指头往这么，越重了，啊，可以到，啊，过腕到肘嘛。啊，“逆冷”他从外边往里头冷，越厥得厉害越往上。这就到这一个地方啊，他把这个厥，他全是反复的说有一种，啊，厥利和热往复；有一种，也有一种热厥，啊；有一种要只是厥热往复没有下利，啊，他也讲了；然后这个厥利往复，要如果阳进阴退，啊，那么就是厥越来越甚，热越来越少，这是不怎么好。否则，这是好现象，啊。这是关于人的这个生死了。那么也有的时候热太过，也不行，啊，那就变成其他的病了，是吧？不是虚寒了。所以我们认为这个厥利往复啊，说的是厥阴病。再讲一段吧，啊，这把底下这个大段讲完了咱们休息。底下呀，他讲证治了。他说厥，啊，对厥这一大段论得最细腻，啊，最多。可见他也注重这个厥。在这个，虽然四种病啊。因为这个厥呢，与这个厥阴病是有关系的。我看是这个样子，啊！

李冠杰：这条在《康平本》里是降一字格排版的条文。条文中的注解“厥者·手足厥冷者是·”在《宋本》里后边还有个“也”字。下边解读一下：

“凡厥者”是指四肢厥冷的厥逆症而言，“凡”字就包括了各种病理状态下出现的厥逆症。用今天的话来说就是：只要出现四肢厥逆这类的症状，都是该条后边解释的这个原因。

“阴阳气不相顺接，便为厥”，这是古人对厥逆症的病理机制的认识。虽然今天感觉这种论述有点过于笼统，但如果从中医的角度理

解，它绝对没有肤浅的意思。在中医理论中人体不仅有血液循环，同时还有经络的循行等等其他的生理活动。所谓的“阴阳气”，实际上就包括了所有这些生理循环过程。如果用现代科学技术研究或者现代医学的最新研究成果来看，不仅仅是血液，人体内的循环和代谢因素也是多方面的。即使科学技术高度发展的今天，如果用现在的科学知识把“手足逆冷”这种症状的病理给解释清楚的话，恐怕也就是“人体循环状态不太好或循环状态不良”等这类比较笼统地解释。实际上现代医学对人体的研究大部分都是静态的，真正动态的并不是特别深入，因为受现代技术手段限制。无论是从现代医学角度还是经方医学角度来看，人体出现“四肢厥逆”的症状，根本原因是肢体缺乏营养造成的，但是形成这一局面的原因却是多方面的。比如“四肢厥逆”这类的在中医概念里是一个了不起的大病，一般这类的症状中医看得都比较重。但是很多在中医看来挺重要的症状反应，在现代医学里实际上其根本原因就解释不太清楚，认识还不到位，常常都不把它当作疾病。

再比如“多汗”，中医觉得这是个很重要的症状反应，但放到现代医学里往往很多情况下就不作为一种疾病状态。中医对许多症状的分析常是在有了治疗结果之后，通过治疗结果再往回推理，推出来造成这些症状的机理。比如四逆汤证的“厥逆证”是在四逆汤证里比较常见的一种症状，它的机理就是人体机能偏于沉衰所造成的血液不达四末。

另外，凡是有中医知识的人都会知道这个“厥”就是手足逆冷，而且这个书里提到的厥冷也好，厥也好，多数也都是这个意思。这里为什么特别加一个注解，其他的地方为什么不加？实际上这有言外之意的，我试分析一下，大家看看是不是这个意思：这个地方虽然也有“厥”字，但是这个“厥”不是“厥阴病”的“厥”。假如没有这层意思的话，加这个注解就没有意义了。那为什么要加这个注解？因为

条文里论述的非常清楚，这个“厥”是“阴阳气不相顺接”。大概当时的医学家们至少一看都会知道，“阴阳气不相顺接”就是现在说的循环系统状态不好了。因为他把机理已经解释清楚了，所以说它就不应该是厥阴病，跟厥阴病不是一回事，所以此处要加一个注解。特别是这一篇中，也就是本条上边的数条条文和下边的数条条文中的“厥”大都是“厥阴病”的意思。这里我是这么认为，大家可以分析。

这么理解有什么意义呢？因为在厥阴病的条文里很多论的是“厥逆症”而不是“厥阴病”。如果仔细去揣摩研究，就会发现这个条文的作者，特别是降两字格排版的条文作者实际上是把“厥阴病”和“厥逆证”混淆了。上次学习时有一个明显的证据，这次的条文里还有这样的证据。后边的条文里就说有了“厥逆症”以后要让你去灸厥阴，为什么灸厥阴？他还是认为厥阴得病了。他不仅认为是厥阴得病，而且还认为是厥阴经络得病，这里边就差很远了，后边还要讲这一层意思。当我们想到这一层的时候，反过来再去重新审视这些降两字格排版的条文，好多地方实际上跟经方理论是相悖的。尽管明显能看出来他是小心翼翼的到处都在想办法让自己的条文符合经方理论，但是因为从根本上对经方理论理解上有偏差，所以时不时的就把他的真实意思给露出来了。

伤寒脉微而厥、至七八日肤冷、其人躁无暂安时者、非为蛔厥也、此为脏厥。（注）蛔厥者·其人当吐蛔。（论）令病者静、而复时烦、此为脏寒。（注）蛔上入其膈·故烦。（论）须更复止、得食而呕、又烦、烦者蛔闻食臭出·其人当自吐蛔、蛔厥者、乌梅丸主之、（注）又主久利。（338）

注：《宋本》此条文如下：

伤寒脉微而厥，至七八日肤冷，其人躁，无暂安时者，此为脏厥，非蛔厥也。蛔厥者，其人当吐蛔。

令病者静，而复时烦者，此为脏寒。蛔上入其膈，故烦，须臾复止，得食而呕，又烦者，蛔闻食臭出，其人常自吐蛔。蛔厥者，乌梅丸主之。又主久利。

乌梅三百枚 **细辛**六两 **干姜**十两 **黄连**十六两 **当归**四两
附子六两炮去皮 **蜀椒**四两出汗 **桂枝**六两去皮 **人参**六两
黄蘗六两

右十味、异捣筛、合治之、以苦酒渍乌梅一宿、去核、蒸之五斗米下、饭熟捣成泥、和药令相得、内臼中、与蜜杵二千下、丸如梧桐子大、先食饮服十丸、日三服、稍加至二十丸、禁生冷滑物臭食等、

胡希恕：那么头一句话“脉微而厥”，脉微就是虚呀，再厥，啊，那虚到家了。他说这个“脏厥”就是指胃，啊。那就…古人就指着脾胃了。“至七八日肤冷”，不但四肢厥，而营卫也不行了，啊，所以这个全身的这个皮肤都冷了。“其人躁无暂安时者”，这个躁最坏了！咱们头前儿也讲了。这个烦是热，这个躁是乱呐，啊，这个人这个，啊，所以邪盛正已经虚了，不能胜邪了，这个人的这个，啊，只躁而不烦了，这最坏。而且无暂安时。此为“脏厥”，这脏气虚败的这么一种厥了。他言外这是死症。就是咱们先前讲那一个胃气已…啊，胃气已败。这一个不是所说的蛔厥了。可见这个蛔厥是厥阴病，啊。真正那一个，啊，胃气已败了，那是不行了。我们现在讲呢？蛔厥，这蛔厥者，其人当吐蛔呀，啊。那么蛔厥不但他吐蛔，这个其人呐，“令病者静”，这个病他这个脏气没有虚衰那么样儿，这个病人呐，那非常安静，没有“躁无暂安时”那一种情况，那么为什么他有时候也烦呢？“而复时烦者，此为脏寒”呐，这就是，啊，胃有寒而已呀。这个寒往…往上攻么，就头前儿讲那个，那个厥阴病的提纲啊，与这一个有些相似，啊。此为脏寒，这个下边寒往上攻。“蛔上入其膈”，迫这个蛔呀，在胃里呆不了了，它往上跑到膈这块儿了。所以它这么

一闹腾，人就烦。他这么个烦，“故烦”。虽然是烦，但是很短时间，“须臾复止”。哎，它到上边不那么凉了它也不闹腾了，不闹腾了这…这…这个也就不烦了。不像讲那个脏厥，真正胃气已败了，那这是老那么闹腾，那也不是烦而为躁了。为什么要吐呢？“得食而呕”，那么这个时候他又烦了一阵，这证明这个蛔厥的这个情况了。他就认为这个蛔它跑到膈上来了，啊！“闻食臭出”，你一吃东西，它先，啊，得着这个食味了，它就往上跑，一上跑，你还不恶心呕吐嘛，啊！“其人常自吐蛔”，这时候你烦一…烦一阵，把他吐出来也就拉倒了。所以蛔厥呀，的确与这个脏厥是，啊，这差之千里的，那绝不一样，这不要紧。“蛔厥者”，那是能治的，“乌梅丸主之”。又主久利方，那这个乌梅丸呐不止治蛔厥，久利、有虚寒的情况也可以用的。这一段讲得很好，啊！我们看看这一个，颇似讲的厥阴病。可是呢？厥阴病这个消渴什么都没有啊！它与那个它提纲合不上。所以张仲景在这一个地方啊，哎，他在这个厥…这一个阶段，与这一个厥阴病很有，啊，很有必要把它提出来的。而且他列这么一个“具体证治”，专治蛔厥的这个方子。这一个你要搁到跟前儿呢，我们看一看，搁到这个厥阴病这个四个跟前儿，他与这个提纲搞不到一起，所以他没办法，啊。可见这个提纲与这一段它不是属于…啊，他不是一个人搞的，啊。那么这个方子啊，很好，这个方子的是真正的虚寒久利不已可以治的。而且驱蛔呢，也是有一定的作用的。他是既要用这个附子、蜀椒，啊，啊…干姜、细辛这个诸大温大热之药，以温中祛寒呐，啊！回阳，咱们就说是了；另外呢，他要用黄连、黄柏解烦治逆。这个黄连黄柏这苦寒药啊，它虽然苦寒，它燥，它能够治这个下利，下利这一个，啊，啊…不用芩连的很少，同时他有烦。这一个，啊…这个蛔厥它也有烦呐，啊，它虽然它不那么燥，它也解烦。那么最…他还是主要的他是胃不好啊，胃虚啊，血也虚。我们讲这个厥阴病“津液虚、血虚”，这个津液虚、血虚不健胃不行的，他既用这些诸温性药，他又加人参；

那么，对于血液呢，他也用当归，啊。这就是补益其气血了嘛，啊，而总是还是围绕健胃了。最妙是乌梅，他以它为主。这个乌梅这个药啊，是酸药都收敛。他这个酸药是大量用啊，啊，酸能解渴，而且乌梅这一个，它是一个清润止…啊，酸敛止渴这类药。所以这个厥阴病，啊，虚他要渴。所以他这个有止渴的作用，但是不是“治消渴”。同时他这个酸敛既能够制这个诸温，你像这个细辛、干姜、附子、蜀椒，这么大的温性药，啊，不让它太散了。这个治这个阴虚证啊，太散了不行的，出大汗呐。这个乌梅呢，收敛，啊，它也能够敛着它不让它辛散太过。同时呢，它与这个芩连搁在一起更能治下利。这个乌梅呀，啊，治下利很好的一个东西，啊。所以他用它为君，有几方面的作用，啊，另外他又调了以蜜，而为丸，啊。这也是安中补虚嘛。所以这一个方子虽然寒热并…并用，但是，啊，是互不相干。所以这个古人这个方子，有的是的，不像现在，一遇着这个热病了，啊，马上都是寒药。有一…有一点热药，你怎么搁这个热药呀？他不是那个，这个方剂配伍啊，他有，他古人他是根据通过实践嘛。这个方子要是这个久下利，你们可以试验，用它是挺好的。但是啊，不要用汤，汤药，啊，还是要用丸药，这一个还是挺好使的。当然要是这个，啊，啊…四肢厥冷吐蛔这种病当然也可以用。今天咱们讲到这了。这一个很有意思，啊。这个后来我们越讲越清楚了，准知道他这个与厥阴病无关。但是头前儿这个呢，还是像有关系似的，啊。有关系，我们讲这个厥，也不净是厥阴病，你像这个热厥，阴证无热证啊，是阴病没有热证。热者不会为阴的，在他这个书也讲了。那这个热厥他决不是讲的厥阴呐，嗯。那么这一个，唯独这个证治，啊，这一个大概他是，虽然说得是治厥，有这么种厥，需要用这个方子，但是这个证治啊，是合乎厥阴的。所以他这个用意呀，啊，很深远。这个大家看一看，啊。

李冠杰：第 338 条既有旁注又有附注还有嵌注，如果仔细分析本条还要复杂得多。这条在《康平本》里是降一字格排版的条文，因为

要把注解内容篡入到正文里去，《宋本》就成了如下的样子：“伤寒，脉微而厥，至七八日肤冷，其人躁无暂安时者，此为脏厥，非虺厥也。虺厥者，其人当吐蛔，令病者静，而复时烦者，此为藏寒，虺上入其膈，故烦，须臾复止，得食而呕，又烦者，虺闻食臭出，其人当自吐虺。虺厥者，乌梅丸主之。又主久利。”下面解读：

（乌梅丸）这个方剂应该是个比较重要的方剂，如果把这个条文方方面面都分析到了的话，几乎就会发现该条文就是这本书的一个缩影。下面逐步分析。

这条如果从《宋本》看，它的述症与论理是论述清晰、语言流畅的。在《金匱要略》里也有该条文相当一部分内容重出，可以拿过来作对比参考。如果把这些主要版本的内容都集合到一块儿，整体地再来分析，这条就存在着很多疑点。

首先，这条既有正文又有嵌注又有旁注还有附注，也就是说该条文的内容至少是由三个或四个作者所作，另外该条里恐怕还有顶格排版作者的内容。而且该条的正文在《康平本》里又是个降一字格排版的，从这儿就能看出参与编写这本书的作者们，包括注解内容的作者，人数比现在知道的还要多。现在知道的顶格条文是一个作者，降一字格排版条文是一个作者，降两字格排版是一个作者。所以我曾经跟大家说过，这个嵌注、旁注是谁作的，现在不敢一下就套在哪个人身上，从这个地方就能看出来了。

再一个《康平本》里该条文中有两个明显的错字，一个是“令病者静”的“令”。这个字在《金匱要略》里是“今”，按条文的意思应该是“今”字，后边还要分析。再一个《康平本》里“须更”应该是“须臾”，明显地《康平本》里是个错字。从这儿能看出该条文很可能在《康平本》时期就已经很不完整了。再看看加了这么些注解，估计就有不完整的情况，甚至是不是一个地方的内容凑起来的。大家学学就能品出来。

还有这条和《金匱要略》重出的部分略有差异，而且《金匱要略》的条文里也包括了该条文的嵌注和旁注内容。这说明一种可能性是《金匱要略》里的条文在后期整理的时候曾经参照了该条文做过修改；另一种可能性是《金匱要略》的条文很可能是从《伤寒论》里抄过去的。以上都是一些可能性，但这些东西不可能是偶然发生的，里边肯定得有原因。如果再深究有一点是不能错的，就是《康平本》的真实性从这些事上能看出来不容怀疑。要有兴趣的话再去看看《金匱要略》的条文，没有人可以用那样的条文改成现在《康平本》这个样式。谁能在毫无根据的情况下把《宋本》的条文改写成《康平本》这样的条文？好好的文字给改成有旁注、嵌注，还有附注，做不了的，这就肯定了《康平本》的真实性。我们现在研究的这些问题，都是建立在《康平本》的真实性的基础之上。

下边再从内容上看。如果想正确解读该条文，有个关键字非常重要，就是“令病者静”的“令”字。在《康平本》和《宋本》中都是“令”字，所以历代注家没有一个认为应该是个“今”字。但是今天通过多方面地比对发现在《金匱要略》里应该是个“今”字。在《金匱要略》第19篇乌梅丸证的条文里是这样论述的：“蛔厥者，当吐蛔，今病者静，而复时烦，此为脏寒。蛔上入膈，故烦。须臾复止，得食而呕，又烦者，蛔闻食臭出，其人当自吐蛔”，后边是“蛔厥者，乌梅丸主之”。尽管《康平本》和《宋本》都写成了“令”字，但是字总是要为内容服务的，仔细看一看该条文，就会发现此处“令”字不对。从头再来看该条文，如果把这个字改过来，整个条文的意思就豁然发生了很大的变化。

该条文和《金匱要略》的条文比较，条文之首比《金匱要略》多了“伤寒脉微而厥，至七八日肤冷，其人躁无暂安时者，非为蛔厥也”这二十五个字。从该条文的字面解读可以明显地看出，既然患者“其人躁无暂安时”没有安静的时候，那其后的“令病者静”如何能让病

者静下来？这里又没有给办法，那怎么可以让患者静下来？这不对。这里不通顺，意思都接不上，但如果“令病者静”是“今病者静”，文意就非常合乎逻辑了，虽然是一字之差，整个条文的意思就发生了很大的变化。我们再来看：“伤寒脉微而厥、至七八日肤冷、其人躁无暂安时者、非为蛔厥也”这论述的貌似是蛔厥，但在病理上却与“蛔厥”（蛔厥：因为蛔虫造成的厥逆证）无关，不是同一种类型的疾病。

《金匱要略》里没有这段文字，它在警示读者不要把这类的表现为厥逆的病证当做蛔厥来治，不但治不了而且还要出事。大家想想这是个什么样的病变？一开始有点伤寒症状，但是脉又微又四肢厥逆，而且到了七八天时还“肤冷”，人到后来干脆“躁无暂安时”了，一直烦躁没有静下来的时候的一种情况。实际上这是一种外有表证里有虚证，而且虚证到了七八天时加重了，陷于阴性重证而表现出来的一种病危的状态。所以这不是蛔厥，像这种情况要是喝乌梅丸的话，那人还不死了？这大概是一个通脉四逆汤证或者通脉四逆加猪胆汁汤证一类的方证。所以这种情况条文告诉你这不是蛔厥，不要当蛔厥来治。

旁注“此为脏厥”在这里可以起到强调上述疾病性质的作用，在经方理论中这就是阴性的里虚寒证造成的厥证。

再接下来是嵌注：“蛔厥者、其人当吐蛔”，在这里有承上启下的作用。为什么上边那些文字论述的不是蛔厥？因为蛔厥可能会有吐蛔的情况。现在结合临床实际看，不一定所有蛔厥的病人都会有蛔虫吐出来，但是这里告诉你了。另外一层意思，一旦出现吐蛔的话，绝对不是里虚寒证。实际上两者其他的区别也非常明显，里虚寒证是“躁无暂安时”，蛔厥是“一会儿一烦”。这里一方面阐明了蛔厥与里虚寒证的区别，另一方面补充后边条文中症状反应的内容。因为“吐蛔”在后边条文里没有这个证，放在此处既起了与前边的论述鉴别，又给予后边的内容以补充的作用。

当看到这儿再来看“令病者静”就没道理了，应该是“今病者静”。

前边讲过，另一种厥逆证看着有点与蛔厥相似，但不是一回事，那个不是一阵一阵的。蛔厥是什么样的？是“今病者静”平时看着还静，“而复时烦”就反复地出现烦躁，“时烦”一阵一阵的，现在说的阵发性的，这里意思就非常清晰了。

实际上那一段内容（25个字）是另外的意思，所以在《金匱要略》里没有。在这儿就非常清晰地看出来，此处应该是个“今”字，而不是个“令”字。那么旁注“此为脏厥”的论述就不准确了，正文此处指的是里寒或者下寒，但是“脏厥”包括的范围就太宽了，中医里的“脏”包括心、也包括肺等等，但是乌梅丸证是一个上热下寒证，或者说是半表半里的热证和里寒证，所以把乌梅丸证定为脏寒不够准确。

嵌注“蛔上入其膈、故烦”，这是对正文里因为有蛔虫病所造成的病人“今病者静、而复时烦”这一类特征性症状反应的病理解释，说明人体内部发生了什么问题，这是古人经过长期的临床观察和分析以后得出来的结论。蛔虫是一种寄生在人体消化道内的寄生虫，凡是这类寄生虫都有一个共同特点，对生存环境的温度、酸碱度或其他各方面的要求都非常苛刻。只要人体出现偏差，它就不太适应了。当人体出现上热下寒乌梅丸证的时候，消化道内的温度因为里寒低于正常值，但胸膈以上的部位反而偏高，于是蛔虫就本能地向着至少在温度上合适的地方移动，也就是说会上移，但是移动到哪儿呢？首先最常见的就是胃部，或者胆囊中，进胆道就不得了了，就会移动到这些地方。虽然这些地方的温度可能会感觉稍高一些，但这个环境并不真正适合（像胆道里有胆汁，浓度非常大，跟肠道里不一样；胃里还有胃酸，也不是适合生存的环境），这时不单单是蛔虫本身不能适应这个环境，人体自身也不能适应这个部位有蛔虫。所以此时，比如胆道里进了蛔虫后，人会出现剧烈的疼痛，这时就形成了一种特殊的局面：为了适应温度蛔虫要尽可能往上升，行至一定部位以后，不单人体因

为极度的不适应而出现剧烈反应，蛔虫本身也没有办法适应新环境，就会出现时进时退的状态。往上来温度好一点，但环境并不好；往下去又凉，就跟水下的动物上来呼吸一下又赶紧缩回去一样，就造成这种时而挣扎时而平静的情况，那么表现在人体上病就“而复时烦”。这是古人从实践中总结出来的对这种疾病的认识，虽然论述方式和语言与今天的不同，但是从病理上来说跟今天研究的这一类病理毫无二致。

接下来“须臾复止”在《康平本》里是“须更复止”，“更”字不对，应该是“臾”，须臾是时间比较短暂的意思。那么“更复止”好像是说有人为干预的意思，在这个地方也不太合适。“须臾复止”是进一步地论述前边“病者静而复时烦”这一类症状反复发作的特点的。

“得食而呕，又烦，其人当自吐蛔”，这里的“呕”有两方面的原因：第一，是人体本身就有里虚寒证，所以胃肠功能本来就比较虚弱；第二，是吃进去新鲜食物以后对蛔虫产生的刺激。本来蛔虫在这个位置可以老实一会儿，也不敢再往上走了，往下面去又凉，好不容易找到一个差不多的位置，但这时突然吃进去食物，刚吃进去对蛔虫是一个刺激，它见到食物马上就会剧烈活动，因为环境变了，其剧烈活动又对胃产生了剧烈的刺激，人就会出现呕吐，在这个时候人就有可能把胃中和食物混在一起的蛔虫一同吐出来，这就出现了“其人当自吐蛔”的现象。

为什么蛔虫见到食物会闹腾，为什么会烦、会有剧烈的反应？下面分析旁注“烦者蛔闻食臭出”就解释了，这完全是主观猜想。恐怕现在还有很多人在这么想：人吃进去食物以后，虫子也饿了，不赶紧去抢着吃么？实际上这种猜测和事实不符，但这个作者就是这么认为的。事实上蛔虫是一种寄生在肠道里的寄生虫，咱们吃到胃里的食物都是还没有消化的，这些食物蛔虫是吃不了的，它吃的东西都是经过

在胃里腐熟、接近半消化的东西，只能进入肠道、需要肠道吸收的那部分。而且吃进去的食物温度肯定跟它的生存环境也不一样，咱们哪有量着食物温度吃的，或吃的东西热，或吃的东西凉，反正总是不那么恰好。但是在胃里经过腐熟消化后再进入肠道的食物，等待肠道吸收的那部分的温度就比较正常了。所以这时新鲜的食物进入胃以后，温度也发生了剧烈的变化，它的生存环境的酸碱度等等的又发生一次变化，所以刺激了蛔虫就会有剧烈的反应，并不是争食吃。这是对此种病理看谁解释得更正确、更客观一些，对治疗疾病没有质的影响，但对于理解这个症状却是非常重要的。

“蛔厥者，乌梅丸主之”意思是：凡是有蛔虫或者得乌梅丸证的这类患者，常常伴有手足逆冷的症状。这里再次强调“蛔厥”是因为有蛔虫，所以给起了个名叫“蛔厥”，本意上说这是由蛔虫引起的厥逆证。实际上这个方证不仅仅是治蛔虫的，它是一个标准的厥阴病的方证。所以也可以理解为在厥阴病的病理状态下以上述症状反应为主，同时伴有厥逆证的，就是乌梅丸证。

对于该条文论述的内容，上面做大量分析的目的是要客观地、准确地去理解它，从各个方面都放在一个恰好的位置上，免得在理解上出现偏差。该条文论述的实际上是乌梅丸证中一种较为特殊的，但在当时的历史条件下却很常见的表现形式。乌梅丸证实际上就是人体机能偏于沉衰的情况下发生的寒热错杂证中的一种典型的疾病形式，在经方理论中就把它归入阴性的半表半里证，也就是厥阴病。但是今天用病理辨证体系来套的话，其病理就要复杂一些，后面会再做个更准确地总结。

前面学习时已经讲过，这个方证在没有蛔虫的情况下（现在大部分人都没有蛔虫了），应该表现为厥阴病的提纲条文（第 326 条）所论述的症状反应。但是当人体内有蛔虫时，就是在上面分析的那些病理因素情况下，蛔虫在这种上热下寒的环境中就会从下往上并再现逆

行的情况，所以才会在人体中出现该条文里论述的这种人一会儿一烦的特殊症状反应。由于古代人体内有寄生虫的情况比较普遍，因此只要是得这类疾病的人，差不多占百分之七十都有这种反应，所以这里就把它作为一个单独的条文、一个很重要的内容来论述。实际上经方里很多方证都有这类条文：比如论述桂枝汤证的条文不下十几个，但这些条文中有一部分只是论述了桂枝汤证的某一个比较典型的症状反应，此处也是这个意思。总体上，在没有蛔虫的情况下表现为提纲条文述证的情况；在有蛔虫的情况下则表现为该条文述证的情况，两者都是乌梅丸的治疗范畴。

乌梅丸证的病理：阴性半表半里虚热证合并里虚里寒证合并血虚证。

因为该条文内容非常繁杂，所以下面做个篇幅稍长的小结，目的是把条文的原意用今天的话陈述出来：病如伤寒，患者表现为脉微而厥，到七八天时出现肤冷，其人躁无暂安时的，不属于蛔厥，这是里寒证的症状反应；如果是蛔厥的话，患者常会出现吐蛔的情况，现在患者虽然也有类似上述的症状，但却表现为时而平静，时而烦躁，这是由于蛔虫上行至胸膈部位所造成的，其特点是短时间内便会自行停止；但吃食物后，则会出现呕和烦躁的症状，此时患者常会出现自吐蛔的情况，这种蛔厥为乌梅丸主治之证。此方还可治疗久下利。

讲一个此方治久下利的案例：去年有一个将近 80 岁的男性患者，条文里论述的典型症状几乎都没有，但就是久下利，好几年了一直大便不成形，再就是典型的阴性证，没有精神。就诊的时候给他号脉，他就打不起精神，明显地有上热下寒，但也没有第 326 条里说的那种胸部疼热的感觉，也没有那么典型，我就给他乌梅丸。后来他儿子说一开始他爸回去吃这药又苦还酸溜挺难吃，吃了二三天觉得没太大效果就再没吃。后来他儿子又给他做工作又接着吃，结果慢慢地脸色、精神、体力、大便等等全都正常了。今年他儿子来没带他父亲，他说

你就再给我弄点那个药，这段时间老爹又不如前段时间那么好，他又拿了一些药走。

当然临床中比较忌讳这类光凭着理念，症状对的不是很准确的治法。但这是一个特殊情况，厥阴病里就这么一条，而且就这一个方证是真正的厥阴病。古人总结的东西都是非常典型的，一旦陷入阴证又有寒热错杂的情况时，比如厥阴病以及其他类似厥阴病的（严格地讲不能算到厥阴病里），几乎就这一个方证。但是再去看看其他的方子，比如少阴篇里的咽痛就弄了那么一大堆，因为各有各的不同情况。从这个角度仔细研究经方这二百多个方子，实际上各类典型情况都总结的很到位了，甚至有的方子是重复的。比如承气汤有三个方子用的药相同，只是比例之间有一点区别；还有三个泻心汤（半夏泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤）的方剂几乎药味差别很少。为什么会出现这类情况？因为都已经很成熟了，凡是出现典型症状变化需要对方子进行调整的，或者临床中医者一般想不到要这样调整的，它都给你作了典型的示范。所以有时候在临床中就能感觉到：这种陷于阴证而且又寒热错杂的情况确实不多。

学习这个条文还有一些值得引起注意的问题，包括以下几点：

第一，在厥阴篇的条文里真正论述厥阴病的只有第 326 条和第 338 条（乌梅丸证条文），而且这两条实际论述的是同一个问题的两种不同表现形式，这一点必须清楚。

第二，第 326 条和第 338 条在《金匱要略》里都有重出，但是这两条重出的位置不一样，情况也不一样。第 326 条是重出在消渴病里，这个重出是个错误，我们已经分析过了。将来在学习《金匱要略》的时候去比较一下，如果第 326 条里没有旁注的“消渴”，那这个条文的述症就跟消渴病压根没有什么关系。我们反复强调这个问题的原因是为将来把《金匱要略》的条文更加准确地辨别真伪提供一个思路。

第三，从第 326 条到第 338 条一共 12 条，中间隔了 10 条，这

10 条全都是降二字格排版的条文。事实上第 338 条（乌梅丸证条文）在那些降二字格排版的条文加入之前跟第 326 条是紧挨着的，也就是跟厥阴病提纲条文是一个上下条的关系。而且第 338 条之后的条文，包括顶格排版的条文再没有真正的厥阴病，也就是说乌梅丸证在顶格排版的条文中没有专门的方证条文，因为第 338 条是个降一字格排版的。从另一个方面看，厥阴篇中又汇集了很多跟厥阴病没有关系的条文，比如“呕、利、哕”这类的，这个“厥”两可，因为关于“厥”的条文有的作者就认为他论述的是厥阴病，有的论述的是厥逆证，所以称为两可。所以后边的“呕、利、哕”肯定就不是厥阴病条文了。

第四，第 338 条中有多处注解内容，又有错字，而且和《金匱要略》里重出的条文内容上还有一些差异。这都说明一个问题：很可能在当时这一篇的内容本身就存在着非常严重的零乱残缺的问题，已经很不完整了，但是从《宋本》是看不出来的，必须对《康平本》进行细致地分析才能得出这个结论。

下边是方解，乌梅丸由十味药组成：乌梅、细辛、干姜、黄连、当归、附子、蜀椒、桂枝、人参、黄柏，方剂中只有乌梅和蜀椒两味药在以前的方剂中没有出现过。乌梅在《本经》中是性平，但从实际应用看这个药略偏于寒性，有除热解烦、解烦满以及止咳、止泻的作用。另外还有一个比较特殊的，它对人体消化道内的寄生虫（不仅仅是蛔虫）有麻醉作用，这也是乌梅丸可以治疗蛔虫病的一个重要方面。另外，蜀椒是一个辛温的药，有温中祛寒和发汗解表的作用，药性有点像生姜，所以后世的医家常用蜀椒代替生姜。在这个方剂中主要用蜀椒来温中祛寒，同时对肠道内的寄生虫也有一定的麻醉作用。这个方剂寒热药物并用，乌梅、黄连、黄柏解热除烦；干姜、附子、细辛、蜀椒温中补虚；桂枝去气上冲、心中疼热，本方证本身就有一种冲逆的因素在里面；人参、当归补气血不足。

所以本方剂的适应证就是：阴性的寒热错杂兼血虚证。

下边是临床统计资料中乌梅丸方证的症状反应，出现频率由高到低依次是：腹痛、恶心、呕吐、四肢冷或不温、腹泻、便溏、吐蛔、便蛔、食欲不振、不能进食、烦躁、面色苍白、神疲乏力、汗出或大汗淋漓、大便干或不通、口渴、发热、腹胀、胸胁胀闷、神昏、暖气吞酸、口苦、头痛。

舌质：淡红、红、暗红、绛红。

舌苔：白苔、薄黄苔、黄腻苔、白厚腻苔、白滑苔。

脉象：沉弦或细、弦数、沉迟无力、弦紧或沉紧、沉滑或弦滑。

有机会应用乌梅丸方剂的现代病相当多，这里读一下，大致有个概念。典型的有：胆道蛔虫症、慢性结肠炎、蛔虫性肠梗阻、胆道蛔虫感染、慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、胃酸过多症、胃肠功能紊乱、胃肠奇痒症、胆囊炎、胆石症、肝炎、肝硬化、慢性肠炎、肠伤寒、慢性非特异性结肠炎、霉菌性肠炎、放射性肠炎、过敏性肠炎、肠结核、肠瘀积综合症、不完全肠梗阻；另外还有急性痢疾、慢性痢疾、顽固性呃逆、中毒性痢疾、急性菌痢、乙型脑炎、痛经、闭经、白塞氏综合症、癫痫、瘰病、前列腺肥大、小儿肺炎、哮喘、慢性支气管炎、肺气肿、老年休克性肺炎、神经性头痛、血管性头痛、美尼尔氏综合症、坐骨神经痛、三叉神经痛、带状疱疹腹痛、腰肌劳损、蛋白尿、慢性肾炎、肺源性心脏病、原发性高血压、心肌炎、脉管炎。

还有一些不太常见的杂病，在整理的资料里有 100 多个，甚至还包括像皮肤方面，荨麻疹反复发作，还有黄疸、精神分裂症等一些比较特殊的疾病也包括。这说明阳性的半表半里证是个比较复杂的疾病群，阴性的半表半里证也是个比较复杂的疾病群。

伤寒热少厥微、指头寒、嘿嘿不欲食、烦躁数日、小便利、色白者、此热除也、欲得食、其病为愈、若厥而呕、胸

胁烦满者、其后必便血、（339）

胡希恕：这一条儿他就说的这个“热厥”，啊。所以这个“热深者厥亦深”，那么热微呢？厥也微。所以这个厥呀，不是咱们遇着这个手足厥冷就是一个，啊，属热，也有属寒的，也有属热的。那么这一段呢，他就说是“热少微厥”，热深者厥亦深，热少者厥亦微呀，是吧？所以根据那一段上说的。他这个厥微呀，所以他仅仅“指头寒”。咱们头前儿讲那一个“阳微结”那一段不也讲了吗，“手足冷”，那也就是微厥。这个…它是柴胡证。里头有热，热往上亢，也常常的，啊，有这个厥的发生。“默默不欲食”，这证明，正…正说明这个少阳病柴胡证，“默默不欲饮食嘛”。“烦躁”，啊，心烦喜呕，这个都是柴胡证。那么这一个“微厥”只是手指头寒，那么发现呢，他是少阳柴胡证。那么经过数日，如果小便自利，而色发白，那么这说明这个热没有了。热没有了，厥也就要没有了。那么这个时候如果欲得食，啊，其病为愈了，啊，那就没问题了。他缘起他热，啊，所以咱们讲柴胡证讲过了“邪高痛下，故使呕也”，那就是热郁于这个半表半里的时候啊，他不能吃东西。如果热除，而能吃东西了，那么这一个微厥是一定能好的。这都是论厥呀，他就这个厥的一证，寒热虚实，啊，他反复这么深论。假设要是“厥而呕”，开始是“指头寒”呐，这个又进展了，真正变四肢厥冷了，这个热尽了，是吧？而且，啊，以前只是默默不欲饮食而已，现在呢，反倒呕了。“胸胁也烦满”，这都说这个病进了，这就是变成整个小柴胡剂，开始那柴胡汤证并不明显，到这儿是极明显，啊。如果要是治，冲这个热往前加深，这个厥加重，那么久后啊，一定要，啊，陷于胃肠而便脓血的，而“便血”，啊，这个热伤阴分的时候，他就要…这说是未来的事情了，可以有这些证状发生，这也热有余了。那么我们在临床上也常见着，这个柴胡证常常手足冷啊，头一条儿认为那是寒，啊，那正是一个，啊，热微厥微之象。这个常在临床就能看着这种情况。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。下边解读一下：

“伤寒热少厥微，指头寒”，这里重点论述的是热厥中“热微厥亦微”的情况，就是患了伤寒以后，表现为发热少、厥逆也轻。所谓厥逆也就仅是手指头有点寒，热不重，厥逆也比较轻微。

“嘿嘿不欲食、烦躁数日”，实际上这是典型的小柴胡汤证。指的是由表证已经发展为半表半里证，而这个症状的本身就是一个虚热证。所以若经过数日之后患者出现“小便利、色白”的情况，则说明热证已经解除了，疾病就有望痊愈，这说的是疾病发展的一种趋势。但也有相反的情况，如果患者在烦躁数日之后并没有出现上述“热除”的表现，而表现为“厥而呕，胸胁烦满”的，则说明病情向严重的方向发展了。此时该条文作者认为，假如患者再得不到正确地治疗，就有可能出现便血的情况。

病者手足厥冷、言我不结胸、小腹满、按之痛者、此冷结在膀胱关元也、（340）

胡希恕：所以这个厥证啊，啊，是各式各样的。他上边说的是个热厥，啊，不过“热轻而厥亦微”。那么这一段呢？说明是“伤寒客冷，啊，积于下焦”，那么也可以致厥的。他开始就说了，这个手足厥冷，啊，这个是寒厥了，虚寒之厥了。“言我不结胸者”，上边他是没有病，啊，没有这个结胸，啊，或者是胸满胸…啊，啊…这一种情况。那么小腹呢？啊，满，上边没病，他病全在下焦。那么小腹满，可见在这个脐以上，这个上腹也不满喽，啊，不光不结胸了。那么这“小腹满，按之痛”，肯定里头有结，有所结。那么这是呢，冷结在膀胱关元。这个积冷结于，啊，膀胱关元这个部位，不是结于膀胱里头，啊。这个寒呐，它就下，啊；这个热它上炎。这是个物理了，

在人身上也如此的。你像这个热吧？你像咱们说那个结胸证，它是结于心下，热结心下，啊，那么有热和这个水呢？他又结于胸胁。他有…主要是热的关系；那么这个寒呢？它都是在下焦，啊。这个沉寒积冷结于这个膀胱关元这个部位，所以小腹…小腹满，按之他也疼。那么这一个他是没说治法了，这个治法也在其中了。这咱们就是这个所谓“寒疝”之类的。咱们要研究这个《金匱要略》就有了，啊。所以这一个大乌头煎，啊，都是治这一种病的，啊；你像咱们后头这个大建中啊，或者是这一个，啊，附子粳米汤啊，都是治下边这个沉寒客冷。这，啊，在治法这是在旁的节目他有…有说的。在这儿他是概言之，说这个厥呀，有热，有热深厥深的，也有热微厥微的，厥也有下焦有寒的、积冷的。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。下边解读一下：

这条论述的是一种寒性厥逆的情况，就是寒厥。

“病者手足厥冷，言我不结胸”，这实际上论述的是一种临床诊断和辨证的过程。厥逆证本身可以出现在多种病理状态下，有热厥和寒厥，但病理状态却截然相反。该条文列举了一个排除结胸证的例子，不是因为结胸证而造成的厥逆。虽然是“病者手足厥冷”，但“言我不结胸”，现在应该怎么理解？四诊的过程中没有发现有明显胸部不适的症状（没有结胸证），但却有少腹部的不适感，就是“小腹满，按之痛”这类的症状。实际上这种症状也可能是多方面原因造成的，比如瘀血证、停饮证都可能出现这类的症状反应，但是当这个症状跟手足逆冷同时出现时，按该条文的论述这是下焦虚寒的症状反应。这里的“冷结在膀胱关元”本意就是说这是一个下焦虚冷的情况。

伤寒发热四日、厥反三日、复热四日、厥少热多者、其

病当愈、四日至七日、热不除者、必便脓血、（341）

胡希恕：这个他头前儿咱们有一个“厥利和热”，啊，交替往复，那么这一个呢只是厥、热有往复，意思差不多，啊。那么可见这个厥也有这一种的，啊。这一个由这一个“厥热往复”可以能够看出这个病的进退之机。底下这两节儿都是这个。他说这种，啊，伤寒这一类的病，他开始发热四日，厥反三日，啊，他就不厥了，到第四日复又热了。可热呢？连续又四天。那么发热的日子多，而见厥的日子少，这是“厥少热多者，其病当愈”，啊。这就是阳…啊，阳进阴退嘛，这一个他说的是一种真正的这个虚寒之厥。那么但是热太过呢？也不能好。所以由这个四日到七日，他这个，他这个热始终不断下去了，而热不除。那，这个热它是伤阴的，就是伤营血了，啊，那以后大概要便血的，便脓血的，啊。底下这一条呢，与这个是相反的。

李冠杰：这条是降两字格排版的条文。对这类条文并没有去延伸、去宽泛理解的必要。主要做个直译，然后重点的地方再简略加以分析就行了。

直译：患伤寒后，出现发热四天之后，又出现厥逆三天，若再度发热四天的，说明厥逆证的比重少，发热的比重多，那么疾病即可自愈；如果发热四天后，一直到七天热仍然不退的，则有可能出现便脓血的情况。

该条论述的就是当人体出现发热与厥逆交替出现的这类疾病的时候，发热多的，病势就向着痊愈的方向发展，也就是病势比较轻；但是如果发热太过，也会因机能过度亢奋而发生另一类疾病。

伤寒厥四日、热反三日、复厥五日、其病为进、寒多热少、阳气退、故为进也、（342）

胡希恕：这跟上面正相反。这个就是，啊，阳退阴进，这要在这个虚寒的病，这是一个坏现象，啊。这由于寒逐渐其多，热逐渐其少，

啊，这是阳气在退，那么这个病在进了，啊，所以在这个病上说这是一个往前，啊，深入。这个不是我们方才讲这一个…热厥与这个不一样了，热厥热退病…病好了，这都说的这个寒厥，啊，虚寒之类的。所以在临床上就得，啊，细心观察了。光见着一个厥，啊，那随便就处理，就，啊，啊…那都是不行了的了。

李冠杰：这条是降两字格排版的条文。下边解读一下：

直译：患伤寒后，厥逆四天之后反出现发热三天，然后又出现厥逆五天，说明疾病有一种向恶化方向发展的趋势，原因是寒多热少，说明人体的正气不足，疾病才会呈现这样的发展势头。

这一类条文（包括上一个条文）如果用现代病来对照解读，就是肠伤寒这类的疾病。这类的疾病多有寒热交替的特点，而该条文中对这种情况下出现的疾病的进退规律做了一个相应的总结。针对这个问题我也专门查阅了一些有关肠伤寒的资料，在实际临床中这类疾病并不是条文中论述的按照固定的日期反复交替发作的情况，有的可能连续高热两周至半个月，这里应该把它看作是一种论述疾病发展趋势的需要，就是用具体天数来说明到底是热多还是寒多的问题（热多代表了什么，寒多代表了什么）。

另外这类条文有个特点，把论述疾病的发展变化当作论述的重点，但都没有给治法。实际上这样的条文难以深究，这个病到底能不能治？在这儿看着患者三四天又是发热又是厥逆的，给治一下不就完了么。实际这一类的用经方不是难治的病。但是这类条文毕竟也是古人的临床经验，其实现代医学也有类似的论述，就是说某某疾病是什么原因发生的，发病的过程会有什么样的表现，也无可厚非。但是放到经方书里，顶格条文绝对没有这样的，顶格条文完全都是围绕着治疗疾病这一个目来论述的。

伤寒六七日、脉微、手足厥冷、烦躁、灸厥阴①、厥不

还者死、（343）

注：“灸厥阴”《宋本》作“灸厥阴”。

胡希恕：这是说这个厥，有生死之机，啊。这一段你们回头看一看，头前儿这个，啊，338节，“伤寒脉微而厥，至七八日肤冷，其人躁无暂安时者，此为脏厥”。他为之论蛔厥，脏厥他没出治疗，也没说这个病怎么地，我们当时讲，说这种病是个死症。那么所谓脏厥者，就是脏气衰败，啊，而发生这个厥冷啊！那么这一段呢，就是说的脏厥。可是这一个脏厥呀，它只是，你看看日子啊，所以这个，他这个书啊，你得注意看，他六七日的时候，那一个是七八日肤冷。他这个六七天的时候啊“只是脉微，手足厥冷”，他没再进了；到这个七八日的时候，他才肤也冷呢，啊，他营卫已经绝于外了，没到那个时候。这就说这个脏厥一…啊，一发作的时候啊，有可治之机会，那么如果在六七天以前，只是脉微，手足厥冷。也没到那一个，虽然烦躁，没到躁无暂安时。躁无暂安时就正不胜邪了，啊，那个正气衰败到…啊，已经衰败了，那非死不可了。这一个还烦，所以他烦躁。在这个阶段呐，赶紧抓紧治，可以灸厥阴呐。可见这一段呐，这个脏厥说明的是厥阴病。这个厥阴病的这个脏厥，是…准是指肝脏呀？这不一定。咱们讲这个半表半里呀，这个部位它是诸脏腑所在之地。你像我们这半表半里，就胸腹腔间这一大块儿地方儿。所以上边有心肺，啊，在这个肋下两侧有肝脾，心口儿以下有胃肠，再往下，啊，膀胱、肾，再妇人子宫。人这个脏器大概都在这个胸腹腔间。凡是这个胸腹腔间这一个地方儿要是脏器有病了，大概都反映出来，不是少阳病就是厥阴病。他这个本脏有病。我们说这个里呀，是胃肠的里面，有一种这个病邪的反应，谓之内证。那么假如说这个胃有病呢？啊，这个胃的本身有病所反应出来的这个，未必是里边的病。那么它本身要是机能方面有问题，也有时候为少阳病的，也有时候为厥阴病的。所以这一个大家要注意，啊。那么这一个他说这个，这个脏厥不一定指的

是肝了，但是这一个他是半表半里的证候，而陷于阴证这一种厥冷，那肯定这是厥阴病。所以他灸厥阴嘛。这个厥阴，那么… 他没说什么一个穴了。那么，这个各家的这个，啊，注这一段呐，全是说的这个，啊，太冲穴。这个太冲这两个穴呀，在足大趾，啊，下边后二寸（……（音频缺如）……只躁而不烦这是这个相当的这个，在这个虚寒的证候说最厉害了。

李冠杰：这条在《康平本》是降两字格排版的条文。条文中的“灸厥阴”在《宋本》里是“灸厥阴”，《宋本》里“灸”是对的。

直译：患伤寒病六七天的时间，患者表现为脉微、手足厥冷、烦躁，用灸厥阴的方法治疗后，厥逆仍不得缓解的为死证。

该条文有诸多需要分析的地方：

第一，从条文的述症看，这是一个重症的阴性表证，因为前面有伤寒，这是典型的少阴病中的重症，用经方治疗应该不是一个难治的病。但是这里却对并非模棱两可、不容易辨证，症状表现非常典型的重症教人施以灸法，至于其中的原因条文中也没做任何说明，这是第一个问题。

第二，条文中“灸厥阴”的治疗方法值得进一步研究，虽然没有说是手厥阴还是足厥阴，但指的是厥阴经络是毫无问题的。那么作者之所以用灸厥阴的方法来治疗该条文中的述症的原因就是：这个作者必定认为“厥逆证”就是“厥阴病”，而“厥阴病”就是“厥阴经络”的疾病。这一点很重要，说明这个作者的观点中“厥阴病”与“厥逆证”是相同性质的疾病，这跟经方理论不符。所以降两字格排版的条文中所有关于“厥阴病”的论述都要将这一因素考虑在内而需要做具体的分析，之所以在前边学习的过程中对这类条文都做了一些比较客观的分析，这也是原因之一。因为在这条里就看出来了，就是把“厥阴病”和“厥逆证”混为一谈了。不仅如此，从该条文的述症看这是典型的阴性表证，而这个作者却因为表现有“厥逆证”而当作“厥阴

病”来治疗，甚至进一步认为是“厥阴经络”发病，说明该作者对经方理论其他类型疾病的认识也存在着概念模糊不清。进一步来说，其他降两字格排版的条文也要客观地去看。所以我们应该特别注重这类条文中来自于临床实践的内容，而对于论理部分的内容都要做客观分析。

另外从该条文最后的结论看，“灸厥阴”这种治疗方法也是不对的。这里明显能看出来，若是方法正确，怎么还会有“厥不还者死”这种治不了的情况出现？本质上还是方法有问题。

第三，“灸厥阴，厥不还者，死”，实际上这是对阴性表证的重症采用了错误的治疗方法而造成的医疗事故，是拿自己的医疗事故当做反面教材来教人。该条文论述的原本不是一个不治之症，是给治坏了。

伤寒发热、下利厥逆、躁不得卧者死、（344）

胡希恕：伤寒发热说明这个，啊，邪盛，外邪盛；下利厥逆呢？这是正虚。下利，啊，就是胃虚了，啊，胃阳，啊，这个胃虚，啊，津…这个，咱们说这个…谷气不达于四肢末，则厥，啊，而且胃虚，啊，他这失去收摄，他下利，自下利。那么如果“躁不得卧”胃气已败了，那非死不可。那么这一种证候啊，我们要是看一看，在我们头前儿讲过的，外有热，就是伤寒无汗发热嘛，啊。同时又下利厥逆，在这一个期间急当救里嘛，那就用四逆汤了。如果要等到这个躁不得卧，那非死不可。不到这个时候呢，还可以救治啊。这我们头前儿讲很多了，在太阳篇里就讲，是吧？那么要到躁不得卧，那非死不可。下边这一段也是的。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。

直译：患伤寒后出现发热同时又有下利、厥逆、躁不得卧的为死证。

这条论述的是一种在较为严重的阴性表证的同时，又伴有比较严重的里虚寒证的情况。这儿的“伤寒发热”虽然像是一般的述症，但从条文最后结论看这是一个阴性的重症。“下利、厥逆”说明人体的胃气已经有衰败之象了，如果这时人体再出现“躁不得卧”，就表示阴性里虚寒证已经严重到一定的程度了，所以该作者就认为这是一个死证。仅从该条文的述症看，这应该是白通加猪胆汁汤之类的方证，该作者为什么不用这个去治疗，而把它当成死证总结在此处是有原因的，后边会分析。

伤寒发热、下利至甚、厥不止者死、（345）

胡希恕：“下利至甚”也当急当救里了，不管他热不热，啊。那么“厥不止”，而且又是四肢厥冷不止，啊，这一个下利至甚，这有下脱之象啊，那非死不可。那么在那个，也就是在开端，所以这个当大夫啊，必须知道这个病，啊，不但知道这现实，而且要，啊，知其预后。你像这个上边这两段全是这样子。全是有表又有里。但是，我们在临床上有个定法，里边真虚寒，非舍表救里不可！那么再下利，挺厉害的时候就要救里，不等到这个，啊，厥逆无脉，那非死不可了。这跟上面是一样的，都是一个邪盛正虚，啊。主要应该在这个胃，都是关于胃的问题，啊。胃气是人生之本了，胃气败人必死！这个地方都很好，别看段落小，啊。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。

直译：患伤寒并表现为发热且下利非常严重，同时厥逆不止的为死证。

这条跟上条是相同性质的问题，只是具体的症状表现略有不同，该条论述的是“下利至甚”这一证最为突出。这时下利非常严重，再加上“厥逆不止”，说明人体整个消化系统已经明显衰败了，而且陷于一种滑脱的程度。如果不这样就不叫“下利至甚”了，所以此种情

况比较严重，预后不良。

伤寒六七日、不利、便发热而利、其人汗出不止者死、
有阴无阳故也、（346）

胡希恕：患这个太阳伤寒。六七日以前呐，本该不利，啊。那么到六七天的时候呢，“便发热而利”，这很不是好现象啊。这说明这个六七天不利的时候，这正说正邪交争的时候。那么到六七天的时候，正败了，邪胜了，所以，啊，发热这是邪了，那么“而利”呢，这是一个正不守了，啊。这也说明这是胃了，所以这一个，啊，中医最好的，啊，最精彩的这么一句话就是“正邪交争”！所以我们在这一个，啊，这个临床上也要注意这一个。以前他本来不发热，现在发热，他邪胜了。那么“而利”呢？这是正败了。如果其人再汗出不止…这个下利伤人津液，这个汗出更伤人津液。既下利又汗出这是一个虚脱的现象。什么虚脱？精气！就是津液！那非死不可。这一个《内经》上讲得很好了，这个我给说了多少回了，在《内经》啊，《评热病论》，他说是“今邪气交争于骨肉”啊。这个伤寒指着太阳伤寒，这个头前儿都是啊，这个伤寒这个阶段，就是太阳伤寒这个阶段，这是邪在表，这一个时候啊，就是人的这个精气和这个邪气拼斗。那一个，《内经》这一段说的很好啊，叫…叫“阴阳交”那一段，你们好好看一看，这与我们研究这一个，啊，这一个书啊，很…很起作用的。所以六七日不利者，正是这一个正邪交争这个阶段。就是人呐，打算由表，这个机体打算由表啊，啊，以发汗的作用，把邪来解除。这个《内经》上这么讲的，如果汗出呢，邪退了，他不发热，啊。那就是正胜而邪退了，他那个书上所说的这是“精气胜也”。那么反之，只汗出而反发热，这就是邪胜了。这个出这汗精气往外流了，啊，所以叫阴阳交呢。开始这个阳，啊，这个正本在里头，这个邪气在外头。他阴阳交，他那个阴呐，就指着这个邪气说的，这一段也是这个，啊。虽然汗出，

这一个汗出不止啊，是精气尽量往外泄了，这个邪留到里头了，发挥作用了，发热。怎么叫有阴无阳呢？是光有邪气了。这个正气他指着阳，就是津液。你看看这个书啊。所以这个注家是都…都搞错了，都搞错在这一点。这个，这个历来的注家认为这个阳都是热。他这《内经》上啊，这个阳指的是津液、指着精气。这个张仲景这个书也是的。他净“此无阳也”。你看那个麻黄汤证，啊，“阳气重也”，阳气重不是热重于表，他因为老不发汗，这个津液充实于外。所以这个，啊，津液少呢？此无阳也，不可发汗，都不是指的热。这一段更明白，他由于大汗出不止，人发的这么高烧的，哪来的没有热呀？此无阳也，啊。所以这个，这个注家啊，他就是不是全面看问题，他也不看旁的书。所以他有阴无阳啊，是只有邪而无有正啊。这正是跑哪儿去了？汗出不止与这个下利。丧失津液，津液亡失殆尽了，人就完了。津液怎么亡失？胃败了！所以这个地方都挺好。不但我们要懂得这一个书，啊，同时我们看旁的书也容易理解。你们再好好看看这个各家注的，注这个书，有些地方啊，简直说的是…瞎胡扯。这个医书啊，这个东西不要随便说，误人。这个《伤寒论》呐，这个我…我光写这个…啊…，那不定多少次了，我教，教多…教差不多有三十四年了，我就没敢往外写，往外拿出版，因为什么？这东西误人。

李冠杰：这条是降两字格排版的条文。“不利”前在《康平本》里有个标点，应该去掉。

直译：患伤寒六七天的时间，并未出现下利的症状，但是之后出现发热并同时伴有下利，如果此时患者还表现为汗出不止的为死证，原因是有阴无阳。

该条论述的是一种初发病为表证一类的疾病，但经过数日以后患者没有得到合理的治疗致使病情突然恶化，出现了发热下利且汗出不止的情况。这说明人体在与疾病抗争的过程中处于劣势，并陷于一种整体机能沉衰的危证中，所以预后不良。

伤寒五六日、不结胸、腹濡、脉虚、复厥者、不可下、
此亡血、下之死、⁽³⁴⁷⁾发热而厥、七日下利者、为难治、⁽³⁴⁸⁾

胡希恕：347 条：这个“亡”也当“无”字儿讲了。这也是太阳伤寒，啊。那么到五六天呐，啊，这是病要是去表，传半表半里和里的时间了，啊，尤其是五六日，大概都传半表半里。不结胸，啊，肚子也软，脉也虚，一点实象没有，“而复厥者”，那么这个厥肯定是虚来的了，啊！什么虚呢？津液虚、血液虚。所以他搁个“此亡血”，就是没有血。那么这一个没有血怎么厥呢？这个我们常说了，啊，就是胃虚，谷气不布，啊，所以这个血液不达于四末，他厥。那么这一种厥，这是虚寒之厥了，这万“不可下”呀。“下之”，啊，那利不止，非死不可。这就是我们遇着这个四肢厥冷的病，要摸摸人嘛，不光摸脉了！摸摸他胸满不满呐，啊，心下部分疼不疼啊，摁摁肚子，然后再好好切脉。独虚无实，那么这一个厥肯定是血少，啊，血达不了四末，他厥。所以他说此无血呀，这一个不能攻，不但不能发汗，也不能…不但不能泻下也不能发汗呐，是吧？尤其下，那非死不可。他胃虚嘛，他胃不好，啊。所以他这个“厥、利、呕、哕”这四种病是处处着眼在胃。所以他我们开始讲的时候啊，他是为总结这个，啊，三阳三阴，他拿出与胃有关系的这么四种病来反复讨论，这个地方都特别精彩。

348 条：“七日下利者”也说明，啊，五六天以前他不下利，这个病啊，都是由轻往重上走，这个病都不好治，啊。他本来只是“发热而厥而已”，那么到七日呢？反倒下利了，这说明有这个，啊，正虚，虚脱之象。但是这个病看不出来就死，但是就这个病的进展上看，这是一个要注意，这是个凶险的一个情形，“为难治”。这一个发热

而厥头前儿也应该有“伤寒”俩字，这个《玉函》有“伤寒”，这个书上把“伤寒”给落去了，应该添上，“伤寒发热而厥”，所以他这底下有括弧 17 页啊，你们看看后边注文上就有，应该有个“伤寒”。那么“发热而厥”，厥者就是，啊，这也说明这个胃虚了。胃虚，啊，津液不达于四末，他厥。那么这一个时候不要紧的，那么到七日，他下利了，七日这一天呐，这与上边六七日、五六日你们好好看一看就知道了，到七天，这又要传入这个阳明的时候。那么这个里太虚了所以到这一天他要下利，里虚是哪儿虚啊？胃虚。所以这个胃啊越来越不行，这个伤寒发热始终不去，这也说是正败而邪独留。所以这个病啊，是不好治，看看这个人还能吃不，能吃还能治，要如果再不能吃了，那非死不可了，那一个，啊，胃气已绝了，是吧？所以这个地方他只是说个“难治”，让你考虑，啊。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文，在《宋本》中被分为两段，“下之死”之前是第 347 条，之后是第 348 条。下边解读一下：

先看第 347 条的内容，直译：患伤寒五六天的时间，既没有结胸证，腹部也较为柔软，脉也现虚象，而且又出现厥逆证的，不可用下法治疗。因这种情况已有血虚，里有亡血，所以下之则死。

该条文论述的是典型的虚证，既没有胸部的结实也没有消化道内的积滞，已经患表证多天了又出现四肢逆冷的情况，同时应之于脉也现虚象。这说明不单是人体素虚，而且在抗御疾病的过程中里虚证的程度还有所加重。复厥者就是胃气衰败的一种证候。如果这时再施以下法，就属于典型的误治，必会产生严重的不良后果。

该条文也必定是来自于临床实践基础，或者是作者本人亲身经历，或者是其目睹了别人发生过这样的医疗事故。虽然该条文里论述的使用下法是毫无道理的，并没有用下法的任何依据，但这个情况可以警示后人，凡是遇到这类的情况千万不能使用下法。事实上条文中

论述的这种疾病，要是严格按照经方的治疗原则施治就不会出现，就到不了这种程度。

接下来是第 348 条部分：“发热而厥，七日下利者，为难治”。该条文在《康平本》里和第 347 条是同一段内容，所以这儿的“发热而厥”前应该指的是伤寒，是接着第 347 条论述的，在《玉函经》里“发热而厥”前就有“伤寒”两个字。

直译：伤寒，表现为发热而且四肢厥逆到七天时又出现下利的，为难治之症。

该条文论述的是表证的同时又伴有里虚证，而且迁延数日不愈，里虚证又进一步加重的情况。“伤寒发热而厥”中的“发热”可以视为表证的症状反应，而“厥逆证”是里虚证的一个证候。“七八日下利”外有表证里又虚，到七八天时就出现下利了，说明人体在抗御疾病的过程中处于劣势，造成里虚证进一步加重。这是疾病向着严重和恶化方向发展的一种趋势，而且这种恶化恰恰是里证有所恶化，所以难治。

从条文的述症来看，这应该是一个白通汤证之类的方证。但该条文的作者为什么不用白通汤来治？这一点很重要，因为白通汤是治少阴病的，在他看来是少阴篇的方剂，这里讲的是厥阴病，所以他就不会用了。该作者本身就有把“厥逆证”看做是“厥阴病”的这种认识，所以他难以用治疗少阴病的方法把这个病治好，难治、治不好也就在情理之中了。

从这点上做个小总结：上边好几个条文论述的都是这样的问题。是该类条文的作者没有入门经方体系，实际上论述的很多病用经方是可以治疗的。但为什么不去治，因为他就不认为能治那个病的方子能治疗那个病，因为他觉得那不是那种病。

伤寒脉促、手足厥逆者、可灸之^①、（349）

注：“手足厥逆者、可灸之”《宋本》作“手足厥逆，可灸之”。

胡希恕：这个促脉这个地方我们更清楚一些，这就是寸脉浮、关下沉的脉谓之“促”。这个仲景这个脉法呀，有以“浮沉候表里”的，也有以这个“寸尺候表里”的。这个脉浮见于寸，这说明表未解。这个“促”者是里虚，浮为什么底下没有呢？底下虚。所以这个结胸证，啊，寸脉浮，关以下沉。他这个热在上头，啊，那么关以下沉，啊，他这个因为中间有所隔嘛，所以促脉也是一种这个，啊，结胸证的一个…一个情况。在这儿呢，他说是在表。在表他里虚，所以关以下沉。那么这一种手足要是厥逆，可见这一个，啊，里，这个胃虚相当重了，这要舍表救里，所以他要灸之。专就他这个…啊，就这个胃上说的。那么这一个呢？我们要是吃药呢，当然也是用四逆汤，这也…这个四逆汤啊，就是“手足厥冷”是个…也是个主要证候。这一个不像后世这个说法了。这个王叔和说这个促脉呀，是“数中一止”，这是错的，数中一止那是热极之象啊，那你还？啊。这个手足厥那是热，啊，热厥了，那你怎么还用灸法呀？所以这个促脉，这个各家这个解释也错的，不是数中一止。“促”者短也，啊；“促”者迫也，急迫谓之促。这个脉呀，迫于上，就是迫于寸；迫于外就是浮。又浮又是促于这个寸口，所以他叫做促。这个王叔和他怎么给搞一个“快中一止”？一止就叫做结，无论你快无论你慢，这个脉跳跳止，这就是结，那不能叫做促。所以这个后世注家呀，就根据王叔和，他作的《脉经》嘛，是吧？哎，它是这一系列错下来的。其实这个促不是。来这个书头前儿有了，那葛根黄芩黄连汤“脉促者，表未解也”，他说的很好，啊。这个也是，虽然脉促而表未解，但是手足厥逆，是“里有虚寒”，应该舍表救里。这个灸不是来治表的。咱们讲这个头前儿那火攻，那些段看一看就知道了，凡是表热的证候，没有用灸的。这一个，啊，灸什么穴？他也没提。那么根据头前儿说，也可以灸厥阴了。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。条文中“手

足厥逆者，可灸之”在《宋本》里是“手足厥逆，可灸之。”《宋本》里少了一个字，对了一个字。下边解读一下：

该条文需要讲清楚，所以不像其他条文仅做直译，还要简单解释一下。“脉促”可以做两种解释：第一，如果把《康平本》中降两字格排版的条文视为王叔和所做的话，那这里的“脉促”在其《脉经》中被解释为“数中一止”的脉象，所以此处应该是指患了伤寒的同时又有热象的脉象（又有热证了）。第二，“伤寒脉促”还可以理解为本书第21条论述的桂枝去芍药汤证中与“脉促胸满”较为近似的情况，也就是在表证的同时又伴有里虚证。从该条文的述症和治疗来看，第二种解释比较合理，如果是第一种解释就讲不通了。

“手足厥逆者”，说明同时还有严重的里虚证。这也佐证该条文的“脉促”应该是指寸脉独浮的脉象。寸脉浮常表现为表证之候（寸脉浮候表），这也跟条文开头冠以“伤寒”是相吻合的。尺脉沉弱常候里虚，也跟“手足厥逆”这个症状是相吻合的。

“可灸之”，虽然没给出具体灸何经何穴，但从前边的论述看，这也应该指灸厥阴经。因为该作者就认为厥逆证跟厥阴病是一回事，而且还是厥阴经络上发病。

伤寒脉滑而厥者、里有热也^①、白虎汤主之、^②（350）

注：

1. 《宋本》无“也”字。
2. 《宋本》此处有白虎汤方及方后注，此从略。

胡希恕：这个跟我们讲那了个，啊，厥…厥微它由于热微，这白虎汤热厉害了，是吧？所以“脉滑而厥”，脉滑为里热，里热盛则脉滑又大，是吧？那么如果太阳伤寒脉滑而厥，这肯定是里有热。这就是厥深热深呐，啊，这个热厉害，这个厥当然也就厉害，这干脆用白虎汤。白虎汤谁都知道啊，这是一个，啊，比较寒的药了，它是阳明，

啊，热结于里嘛 但是没到成实的这个时候啊，可以用白虎汤。热去了厥也就已。

李冠杰：这条在《康平本》里是顶格排版的条文。在《宋本》里条文最后附有白虎汤方和方后注解，在《康平本》里没有。“里有热也”在《宋本》里没有“也”字。解读一下：

“伤寒脉滑而厥者”，论述的是白虎汤证中一种较为特殊的症状表现形式。此处的“伤寒”应该是指有表证的某些近似的症状反应，比如头痛之类的；“脉滑”是里热证的典型脉象。它的机理是由于人体的机能过度亢奋，人体内脏器官的温度也较正常值偏高，这时人体内血液的粘稠度在这种偏高的环境温度下就会相应地变小，表现到脉上就呈现为“脉动滑利”的脉象。但该条文里只论述了脉流方面的一种情况，对于脉体和脉动方面都略而未论。此处并不是没有必要去说，而是有不确定的因素存在。

这里只给出一个“滑”的脉象，那到底是洪大还是弦细，是沉还是数还是迟？为什么这些就不说了？学习到目前为止，几乎每个方证凡是能找到临床统计资料的，都会原原本本的展现出来，仔细分析就会发现这些资料的有用之处，最典型的就是大承气汤证，其中表现了二十八种脉象，到底论哪一种？论了典型的脉象，那不典型的就没有了吗？所以从这点上看，顶格条文的论述虽然简单，反倒是非常客观的。相比之下再去看看降一字格和降两字格排版的条文，都有把脉象讲的过于具体和绝对化的倾向。特别是有个旁注给注了一个“寸关尺”，说寸脉是什么样的，关脉是什么样的，尺脉是什么样的，假如实际临床中病人的脉象不是那个样子，但其它的症状都符合那个方证，最后还是得用那个方子治疗。所以别看顶格条文简，简有简的道理，降两字格的条文倒是很详细，详细的有时就绝对化了。

这里再稍微延伸一下，现在社会上不是还有很多中医大家和中医学子都在走这样一条路吗，搞微观脉诊的，甚至有专门搞脉学的。搞

脉学的如果跟临床实际都能接轨，这是功不可没。但是脉这个东西由于比较特殊，病人自己说不了，其他人看不到，问又问不出来，就指着医者自己手下的感觉，所以中医里就把很多这类东西给神秘化了。可以去看看各种各样的脉学理论，非常混乱，但最终都要与临床实践接轨，接不了轨的说的再好也没用。

再回过头整体地看，顶格条文作者论述的脉常常都比较简。脉象的实质就跟一个普通的症状没有什么区别，仅一个脉象说明不了任何问题。比如发热（体温高）在现在所学的六类疾病中都有可能出现，还得去找别的证据。现在跟同学们一块儿交流的时候，恐怕我说的最多的一句就是“你再去寻找别的证据，还得有别的依据”。仅是一个发热，是万万用不了方子的。其实脉也是这样的，若没有其他证据作参考，比如仅凭一个洪大脉就要患者喝白虎汤，这恐怕也不太合适，也不敢让他喝。

接下来“厥”就是四肢厥冷了，这是由于里热过于严重，反而致人体陷于一种循环系统被控制的状态所造成的。所以此时的脉象在“滑”的同时有可能出现大而实的脉，也有可能出现细而数的脉，但是必会现滑脉，因为里热还没去，因此滑脉是比较确定的。所以这里是“择要”论述，其他不确定的因素就不论了。可是在临床学习中得知道，如果搞不清楚，拿这个脉去套，恐怕也成问题的。

“里有热也”，是对上面这种情况所作的病理解释。因为该患者有四肢厥逆的症状，在脉滑的情况下千万不要认为有里寒，这是有里热的情况。在顶格条文里有这种病理解释的情况不是很多，此处有是因为特有必要。实际上这是里热证中的一个重证，也是白虎汤证中的一种特殊现象。如果此时里热再不得去的话，人体就有可能出现不良后果，问题就比较严重了。

该条文论述的是一种里热证而不是厥阴病，这是一个纯粹的里热证，跟厥阴病没有关系。而且在顶格条文作者的理论观点里，厥阴病

和厥逆证是两种性质完全不同的疾病。所以根据这个，我的观点是该条文原本不应该在这篇里，应该在别的地方，是后人把它调整在这儿，就是那些有认为厥阴病是厥逆证观点的人把它调整到这个地方来的。但是现在有一个关于经方理论中条文的位置问题，比如不是太阳病却在太阳篇里，不是阳明病却在阳明篇里，这个问题今天学习时完全没必要在乎。因为有很多原因：有的是为了阐明病理，有的是为了阐明治疗原则，有的是为了阐明疾病发展变化的规律，有的是别人改动的。所以不要在乎条文是不是这一篇里的，应该关注它具体说的是什么，正确理解了以后，条文位置在哪儿都没有关系。

前两天有个同学给我留言，问桂枝加厚朴杏子汤是不是应该有半表半里证？今天就借助这次学习的机会，顺便把该问题澄清一下：界定桂枝加厚朴杏子汤证的关键是症状。那么症状就是喘家，喘家就是人在没有表证的时候也有喘的问题，这个喘就不是表证了，跟表证无关，就可以认为是有半表半里证。但是从药物和方剂上看，可以认为有半表半里证，但是半表半里的寒热倾向就不是十分明显了，这是其一；另外因为喘家就应该偏于虚，可有一个问题，不要把眼光盯在这儿，要去整体地看这个方证。该方证主要的病理基础是表虚证，桂枝汤才是基础。所以说主要矛盾是一个桂枝汤证，在桂枝汤证的基础上又有一点半表半里，本来桂枝汤证有时也会出现咳嗽，但素有喘疾的人如果再出现桂枝汤证，这时表现为桂枝加厚朴杏子汤证的机会就比较多了。因此这个“喘”就应该算半表半里，但是占的份量要小得多，辨证的重点应该放在有没有桂枝汤证上。

手足厥寒、脉细欲绝者、当归回逆汤^①主之、（351）

注：“当归回逆汤”《宋本》作“当归四逆汤”，后同。

胡希恕：这一段肯定说的这是厥阴病。“脉细欲绝”呀，这是个血少啊，啊。血少而“手足厥寒”，所以他用当归四逆。他这一段呐，

也有很…也有让人值得考虑的地方，全书都是“厥冷”，啊，或者四肢逆厥，他这一个搁个“厥寒”。那么这个方剂里头呢，他以桂枝汤为基础的，你看它桂枝、芍药、甘草、大枣，他以细辛换了生姜了，另外加上，啊，当归、通草。那么这个桂枝汤它治外寒的，那么也有说这一段呐，啊，是由于这个血虚血少，而寒客于内，这个寒呐，啊，寒邪啊，啊，由外往里来，有这么解释的。虽然这个解释很…啊，像离奇似的，可是这一个方剂呀，确实治这个，这个冻疮一类的病相当的好使这一个。这个你们可以试验，要有冻疮不愈呀，这个方子挺好使。它治寒，可是血虚，啊，脉细欲绝嘛，就是脉细呀，似有似无那个样子，脉细为血少嘛。他搁个“厥寒”，啊，怪有意思的。那么这一个四肢厥呀，他由于这个血少的关系，所以这个药，主要的还是补血液、调营卫的法子。当归补血这个都知道了，这个通草啊，你们现在用不要搁通草呀，古的…古时候的通草就现在的木通，这个通草一点用都没有啊。这个木通这个药啊，它是通血脉的，啊。它是有当归滋补，又有通草的通利血脉，啊，所以对于这个，啊，脉细欲绝这一种厥寒起作用。那么这个细辛这个药啊，这是个，啊，跟附子一样大温性药，它通利关节，是吧？那么同时它也祛寒呐。这个血虚到脉细欲绝，啊，内里头没有不寒的，所以生姜没有它好，他把它换成它了。那么这一个方子主要的是内补血气、外和营卫，这么一个方子。那么后世，啊，用这个方子套出了很多的，啊，治这个寒疝这一类的…那是根据下边，不是这一段。这一段肯定这是厥阴病，啊。因为这个，是这个阴病都没有不虚的。虚，主要在哪儿呢？主要在血虚。少阴病也是一样啊，那么由血虚而致厥寒，啊，那么我们补血调营卫，这是个正治，啊，这肯定这是厥阴病。可这个厥阴病也只能搁到这个治厥里头。你要与这个头前儿说，搁头前与提纲也不对口。所以在这个论厥这一章里头啊，有很多与厥阴也…有厥阴病。但是对于提纲上说呢，都不对口，所以他也没法子把这个东西搁到这个厥阴病头前儿，

那四段里头。可见这提纲是有问题的。上次咱们也讲了。

李冠杰：这条在《康平本》里是顶格排版的条文。

“当归回逆汤”在《宋本》里是“当归四逆汤”，这是大家都知道的一般常识。下边解读一下：

“手足厥寒”，是指与手足厥逆、厥冷之类相似的症状。但在此方证中特别用了一个“厥寒”，作者的意思是要强调在当归四逆汤方证中这个症状比其他的症状更为突出，程度也更为严重一些。

“脉细欲绝”，指的是细而微弱的脉象，而且脉细微的程度已经到了似有似无的样子。

上述两个症状都是本方证最典型的症状反应。虽然该条文的述症对这两个症状相对地都用了比较特殊的文字来描述，但仍然可以明显看出这两个症状在其他方证里也属于典型的常见症状，比如在四逆汤一类的方剂中这两个症状同样也是典型的常见证，而且发病的机理是基本相同的，但是其所处的病理状态却有着本质的区别。所以要准确理解当归四逆汤证，还必须结合该方剂的药物组成来对其发病机理做个比较深入的剖析。一涉及到方剂的药物组成，该方剂跟四逆汤类的方剂相比较差得还是非常远。四逆汤一共三味药，这三味药在该方剂中重复的仅有甘草，附子、干姜在这里都没有，所以它们实际上差别还是非常大的。但是这两个症状却非常接近，而且这两个症状作为当归四逆汤证来说又是一个典型的症状，也就是主证。

当归四逆汤实际上是在桂枝汤的基础上去掉了生姜，加上了当归、细辛、通草。当归是温性的补血药物；细辛温中祛饮、通络；通草在以前的方剂里还没出现过，一般说它性平、寒热倾向不是很明显，其主要作用是通络，通利血脉，此外还有利湿、利关节、治疗痈疽恶疮这类的作用。在桂枝汤的基础上加入通草、细辛、当归，增加了治疗血虚和血流不畅的功能。以上是通过药性来分析当归四逆汤的功用。

下面再结合有应用当归四逆汤机会的一些现代疾病，还能进一步加深对当归四逆汤的理解。这里就挑出一部分比较有代表性的、有特点的现代疾病，包括：动脉硬化、大动脉炎、脉管炎、红斑性肢痛、肢端青斑症、肥大性脊柱炎、肩关节周围炎、关节僵硬症、冻疮、多形红斑、过敏性紫癜、硬皮症。这些疾病明显都跟人体的血液循环不良有关，从这里就能看出当归四逆汤有比较强的改善人体血液循环状态的功能。

虽然这些资料对理解当归四逆汤证有一定的参考作用，但应用于临床还是很不够的。因为我们面对的一大堆临床统计数据都是死的，但看数据的人是活的，都应该活着看。前两天我翻到一本书，它是从数据的角度去统计经方药物的作用。比如甘草在多少味药方里出现过；在哪一类方剂里因为有甘草，所以甘草适应了哪一类症状等等。罗列了很多，看了以后会发现一点印象都没有，全是些死数据。所以在这些数据背后能理解到什么，哪些东西能帮助我们理解经方理论，哪些数据仅是一些虚的数字在哪儿摆着，有时候没有太大的用处，我们应该从中去慢慢地、细致地辨析。

从这些现代疾病里大致能看出一个问题，就是都跟人体的血液循环不良有关。但仅是这样的话，这个方子肯定能改善这种情况。但是在临床运用时，还要面临去辨四肢厥冷，脉细欲绝这些症状的情况。这些症状的含意是什么？我们再进一步从经方理论的角度做个分析：这个方子没有附子类的亢奋性的药物（干姜也可包括在内），就可知该方证的问题虽然出在循环系统上，但主要矛盾不是动力不足，用经方理论来说，就是没有出现人体整体机能偏于沉衰的阴性证，到不了那种程度。尽管当归四逆汤治疗的疾病很多，但是有关心脏功能方面的疾病虽然有，但客观地看占得比重不多，这是其一；其二，这些数据统计往往都是在加减的基础上，拓宽了该方剂的应用范围，相当一部分疾病都有这方面的因素，但上面列举的这些疾病，这方面的因素

会比较轻微一些。

该方证的主要问题就是血液流通不畅，那么流通不畅也有它的物质基础。比如大动脉炎，脉管炎这类的，血管本身发炎了，血流肯定就会受到一定的阻碍，这是一方面。另外，如果把血管看成人体输送能量的高速公路，不一定非得得到发炎的程度，路况不好的时候，还到不了非得是封路的程度，同样会影响血液的流通。如果把人体整个的血液循环看做一个运输过程，那么当归四逆汤证的主要问题不是运输能力不足，而是出在车况和路况上，两者都不好，同样会影响到运输能力。

这个方子的基础是桂枝汤，但不管是从经方条文的述症还是从临床统计资料看，该方证中几乎没有任何桂枝汤证的典型症状反应，但是桂枝汤的药理作用并没有因此而改变。这个方剂里除了没有生姜之外，整个桂枝汤的药物全有，所以这些药物的作用不会因为该方剂有变化作用就跟着变了。实际上，桂枝汤本身就有改善体表循环状态的作用，其原本就是通过改善体表组织的能量供给来实现解表功能的。在当归四逆汤中仍然是运用桂枝汤的这个特性，并在此基础上加了细辛和通草，进一步强化了该方剂通利血脉的作用，也就是把这种改善体表能量供给的作用，给引导到更偏向于通利血脉的方面，这样同时就淡化了该方剂的解表功能。所以如果是一个典型的桂枝汤证病人吃当归四逆汤，疗效绝对比单纯的桂枝汤要差很多。

讲到这里就顺便说一下，在经方里这类的特点是非常突出的，最典型的方子就是桂枝加桂汤：桂枝汤中桂枝加上二两，整个方剂的主治就发生了根本的变化。所以经方的一个显著特点就是组方严谨。其他中医的组方本来也应该是严谨的，但问题是没有一套像经方这样总结如此完备的应用指征和应用理论，所以显得那些方剂就可以随意加减。实际上所有的中药方剂都有这样的特点，只是经方这套理论比较完备，好多东西都列举的非常明显的例子，比如合方就有桂枝麻黄各

半汤，桂枝二麻黄一汤，桂枝二越婢一汤等等。这一类的方剂在临床中用的机会并不是很多，举例子的目的就是让你去感悟在许多情况下，这些方剂不是两个方子简单合到一块儿，不是两个方证的简单相加。比如条文里论述的麻黄桂枝各半汤的适应证绝不是麻黄汤证百分之五十，桂枝汤证百分之五十，而是又有一些其他的症状反应。所以中药治病是一个非常严谨和严肃的事。

最终还是那句话，经方不是不可以加减，但经方不能随意加减。这个方剂实际上变化也不是特别大。假设经方里没有当归四逆汤，很可能就有人在治疗桂枝汤证的时候发现患者有点贫血，感觉血脉流通不好，也许就会加减成现在这样，还认为是在治桂枝汤证时兼有这种证的情况。但实际上从该条文的述证和实际临床应用看，该方证中一点表证的影子都没有，此方剂就发生了这么大的变化。也就是桂枝汤加了通草和细辛之后，就如同在人体组织内建立了一个强有力的公路和车辆维修团体，可以改善血流过程中的不良状态，这就给血脉的通畅提供了一个前提条件。

这里顺便说一下刚才的问题：四逆汤类方证也有出现四肢厥冷，脉沉微一类的症状，其病理和当归四逆汤证是不一样的，但机理是相同的，也是体表血脉供应不足。但四逆汤类方证的体表血脉供应不足不是血流问题，不是路况和车况的问题，是动力上就有问题，根本就没有能力送出来，路况和车况都是好的，但是装不上车。另外在当归四逆汤证这种情况下，只是加了细辛、通草改善运输能力还不够，还要有充足的货源做保证，所以这里又加入了当归用来改善血液虚损这一类的问题。

当归四逆汤方证虽然出现在厥阴篇里，但就其病理而言，不具备阴性证的基本特征。既没有阴性证的典型药物，而且在临床中虽然该方证的患者表现出四肢逆冷和脉细欲绝的症状，与阴性证的四逆汤类方证比较近似，但当归四逆汤证没有人体陷于机能沉衰的病理状态。

所以这类患者在临床中没有阴性证那种精神萎靡、但欲寐、体力不支、甚至下利清谷这类的症状反应，这也是当归四逆汤证与四逆汤类方证最大的区别。再进一步说，这两类方证都有脉细欲绝、四肢厥冷这类的症状。因为当归四逆汤是个常用的方剂，在临床中去感悟一下，真要是碰到一个当归四逆汤证的病人让他吃四逆汤也没有太大问题，一般不会有多大的不良反应，但是他的病你给他治不好。比如这个人生冻疮，不单单是冻疮给他治不好，而且就连脉细欲绝改善也不明显，这就让人感觉奇怪了。脉细欲绝吃四逆汤，最起码脉应该有改善吧？不一定一点改善都没有，但是非常轻微，跟真正的四逆汤证吃了四逆汤以后的变化差很远。

从当归四逆汤方剂的药物组成看，该方证的表虚证是一个挺重要的病理因素，但在临床中这类患者常没有典型的表虚证的症状反应，而且是以体表营养不良为主要的疾病特征。这里从方剂上看肯定有表虚证，但有表虚证又没有表虚证的症状，那该方剂到底应该归到什么病里去呢？如果真正按着历代学习经方的那一套，无论是脏腑辨证、经络辨证，甚至是现在比较流行的六经辨证，都很难把该方剂恰如其分地放到哪一类疾病里去，但是用经方病理辨证体系来界定，那该方证的基本病理特征完全能概括进去。

当归四逆汤证的病理就是：表虚证合并血虚证，这是主要的；再细究还有次要的，有里虚里寒证，虽然不重但是有；同时还合并有水实证。需要说明的是该方证中表虚证的病理特征并不是以“脉浮头项强痛而恶寒”这类典型的表证特征表现出来的，而是以“脉细欲绝、手足厥冷”这种肢体和体表组织营养匮乏的形式表现出来的，这就是一个比较特殊的情况。

我们去深究这些东西的原因就是在临床中只要抓住这些方证的基本病理特征，具体的辨证当中与类似方证的鉴别并不困难。现在说完以后大家再简单地回头想一想，该方证跟四逆汤证相比较的话，摸

脉、摸病人的手脚跟四逆汤证是一样的，但是问来问去会发现它没有四逆汤证那些典型的阴性证的症状。

做个小结：以“手足厥寒、脉细欲绝”为主要症状反应的，为当归四逆汤主治之证。

下面看看方剂，该方剂由七味药物组成：当归、桂枝、芍药、细辛、甘草、通草、大枣。这个方剂的药物作用前边在条文的学习过程中把方药都讨论了，这儿就不重复了。

值得注意一个问题：在《康平本》中当归四逆汤在排版方式上是个比较特殊的格式，而且在方剂之前还有“又方”两个字，这是一个比较特殊的地方，其他的方剂也有但是不多，这是其一。另外在《康平本》中该方剂是降两字格排版的，在《康平本》里还有几首方剂的排版是这种格式的，但也是少数。那么有没有另一种可能性？是不是抄错了，就仅仅是起头第一个字的位置问题。再看看该方剂，包括后边的当归四逆加吴茱萸生姜汤，还有这两个方子的方药以及方后注解都是降两字格排版的，那这就绝对不是笔误。这儿就提醒我们，这个方剂以及其他几个方剂，比如麻子仁丸等在《康平本》里的方药和方后注解都是降两字格排版的，但具体的原因是什么，现在不敢妄下结论，这个肯定跟别的有区别，就留作将来再进一步研究。

下面是当归四逆汤的方证，以出现频率最高依次往下排：手足寒冷，这里就包括手足厥寒、手足寒、手足冷、手足凉、手足不温，凡是医案中有这类记录的都在这个范畴；第二个症状是疼痛，包括少腹疼和头疼，像这个头疼不能排除有表证的因素存在，但更重要的还是血流不畅造成的；面白，包括面色不华、面色不荣；畏寒，包括恶寒；还有眩晕、腹胀、便秘、呕吐、口渴，大致是这么多症状。

舌质：主要是淡舌、还有紫暗舌、淡红舌。

舌苔：主要是白苔，还有少数灰黑而润的苔、薄黄苔。

脉象：出现最多的是沉细的脉，其次是弦细的脉、沉细弱的脉、

脉微欲绝、还有沉细迟的脉。

再接下来是该方剂的现代应用，也就是在哪些疾病里有应用机会。量比较多，因为这是个常用方剂，要是用得好的临床中能解决很多问题，如果用得不好，看着好像挺对证但是总会感觉疗效不好。前些年我有过一个经历，一个熟人体格挺壮平常也挺忙活，体力劳作也是经常有。他出现冻疮，手冻了，但是几乎没有其他别的症状，平时身体非常好，也很少得病，这就近似于无证可辨，那就对病吧。后来就给了不到十天的当归四逆汤，结果什么用都没管，根本不起作用。因为他不是那类的情况，也没有手足厥冷的情况，脉还挺壮有点偏向于洪大，所以如果不对证，疗效就不行。这个病人让我当时想了很多，就是经方治病在任何情况下都不能简单化，不能图省事走近路，到最后承载的是疗效。

这里把现代疾病也说一说，大概听一下你会发现，虽然在临床中遇到这个病用这个方剂套是不行的，但是它能虚拟一个轮廓，能大概知道该方剂的治疗方向是什么，这非常有用。现代疾病包括：动脉硬化、大动脉炎、脉管炎、栓塞性脉管炎、病态窦房结综合征、陈旧性前壁心肌梗塞、心力衰竭、无脉症、心动过缓、高血压、脑血栓形成、冠心病、心绞痛、红斑性肢痛、肢端紫斑症、先天性心脏病、肺炎性心脏病、雷诺氏病、慢性支气管炎、阻塞性肺气肿、肾动脉狭窄症、肺气肿，浅表性胃炎、萎缩性胃炎、霉菌性肠炎、十二指肠球部溃疡、胃痉挛、胃神经官能症、慢性肠炎、术后肠粘连、腹痛、胆囊炎、胆道蛔虫症、肝炎、肝硬化腹水、痢疾、习惯性便秘、运动性癫痫、神经性头痛、末梢神经炎、多发性周围性神经炎、急性感染性神经炎、尺神经麻痹、偏头痛、顽固性头痛、神经官能症、急性感染性多发性神经炎、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、肥大性脊柱炎、肩关节周围炎、关节僵硬症、颈椎综合征、顽固性腓肠肌痉挛症、下肢肌肉痛、骨缺血性坏死、骨折愈合延迟、腰间盘突出、精索静脉曲张、精索鞘

膜积液、睾丸炎、附丸炎、输精管结扎后遗症、腹股沟斜疝、前列腺肥大、外伤性阴囊肿大、阳痿、缩阴症、精液不液化、痛经、闭经、不孕症、附件炎、盆腔炎、子宫下垂、妊娠腹痛、妊娠假下血、月经周期性水肿、产后腰腿痛、产后腹痛、产后癆、产后肢体酸痛、冻疮、荨麻疹、进行性指掌角化症、局限性硬皮症、结节性红斑、寒冷性指膜炎、老年性冬季皮肤瘙痒症、老年性黄褐斑、风寒性银屑病、多型红斑、过敏性紫癜、硬皮症、小儿麻痹后遗症、新生儿硬肿症、蚕食性角膜溃疡、视网膜神经胶质瘤。以上大概有一百多种病，都有用当归四逆汤这类方剂治愈的机会。

若其人内有久寒者、宜当归回逆加吴茱萸生姜汤、（352）

又方^①

注：《宋本》无“又方”二字，且当归四逆汤方及方后注在第351条之后。

当归三两 桂枝三两去皮 芍药三两 细辛三两 甘草二两炙 通草二两 大枣二十五枚擘一法十二枚

右七味、以水八升、煮取三升、去滓、温服一升、日三服、

当归回逆加吴茱萸生姜汤^①

注：《宋本》无此方名。

当归三两 芍药三两 甘草二两炙 通草二两 桂枝三两去皮 细辛三两 生姜半斤切 茱萸二升 大枣二十五枚擘

右九味、以水六升、清酒六升、和煮取五升、去滓、分温五服^①、

注：“分温五服”《宋本》作“温分五服”。

胡希恕：这个是，啊，接着上边这一段说的了。那么如果有上边那个情形，由于血液虚而手足厥寒，用当归四逆汤；如果当归四逆汤证，内里头更有“久寒”，这个“久寒”是指着什么说的呀？那么从所加的这个药，他加的吴茱萸、生姜。这个吴茱萸、生姜都是利于胃了，啊！当然这个，啊，里头这个寒总是，还是在胃。而胃寒有呕吐，或者有腹痛的情形，可以加吴茱萸、生姜。这个久寒呢，不是当时有病，一时的这个寒，他平时就有这个证候，啊，有久寒。那么同时再有当归四逆证，可以…所以他才加吴茱萸、生姜。那么这一个当归四逆加吴茱萸、生姜，所以治寒疝嘛，有可用的机会。后世就是用这个，啊，又加…啊，加些旁的这个，啊，祛寒的药，加茴香啊，啊，就是小茴香，啊…加些这个温性药。但是要不是血虚为前提呀，这是不能够乱用这个寒疝，寒疝他主要肚子疼，啊，那一个离不开附子、乌头的，啊，当然细辛也有可用的机会了。

李冠杰：这条在《康平本》里是顶格排版的条文，而且和第 351 条当归四逆汤方证条文是相临的段子、是上下条的内容。并且这两条论述的方剂都附在第 352 条之后，说明这两段文字是互相联系的。实际上解读这个是很自然的事儿，大家心里都明白，但从排版上看在《宋本》里做了调整，把当归四逆汤方剂和方后注解都往上提了，提到了第 351 条之后，这种调整毫无道理！虽然不至于影响到我们没法理解的程度，但这样调整以后文字就接不上上面的气了，所以此调整就是画蛇添足之作。另外从这里也能看出来后世还是有对《伤寒论》版本调整的情况。

“若其人内有久寒”，这里用了“内”字而没有用“里”字，也就是没有说“里有久寒”，实际上这是有分寸的。从该条文和第 351 条的关系和两个方剂的药物组成可以看出，这里指的是在当归四逆汤证的基础上如果患者“内有久寒”的，就是当归四逆加吴茱萸生姜汤方证。

从该方证的临床表现看，其症状反应跟当归四逆汤主要的症状反应基本上是相同的，但加了吴茱萸生姜后临床中多了个显著的症状：恶心呕吐，实际上这就是所谓的“内有久寒”的病理反映出来的一个症状。当然这里的恶心呕吐也算是个典型症状了，但其他的应该还有。也就是说，所谓的“内有久寒”在该条文中指的就是“里寒”，而且主要指的是平素消化道内就有偏于虚寒倾向的这一类范畴。这里用“内有久寒”的主要原因是：用来与四逆汤类方证中的里虚寒加以区别。像四逆汤证中，阴性的里虚寒证不只是表现在消化道内，它是人体整体机能偏于沉衰的一种虚寒证的病理，而该方证的“内有久寒”主要是集中在消化道以内，并且没有明显的整体机能沉衰的病理特征。

要进一步理解的话，可以再去参照“吴茱萸汤证”就很容易理解了。虽然吴茱萸汤证也是个典型的里虚寒证，而且在临床中的症状反应也非常强烈，人都“烦躁欲死”，又呕吐又头疼非常难受，但是跟四逆汤类方证比较还是有很大区别的。该方证是在当归四逆汤的基础上再加上吴茱萸、生姜，说明其里虚寒证明显要重于当归四逆汤，但也仍未达到四逆汤类方证阴性证的程度。

以上都是理论分析，在临床中“内有久寒”主要表现为不喜食冷、不愿喝凉东西，稍微吃点凉东西后可能胃肠就会不适，甚至有时严重了会出现恶心、呕吐、下利一类的症状。但是当这些病理和症状反应跟血虚证和表虚证结合，也就是跟当归四逆汤证再结合在一起时，除了当归四逆汤证的手足厥寒，脉微欲绝之外，还常会表现有少腹冷痛，腹胀（由里虚寒引起的），四肢疼痛这类的症状。

当归四逆加吴茱萸生姜汤证的病理非常简单，就是里虚里寒证合并血虚证合并表虚证。

做个小结：以手足厥寒、脉细欲绝为主要症状反应，同时患者又长期存在内寒的，为当归四逆加吴茱萸生姜汤主治之证。

下边看看方剂，该方剂由九味药组成，就是在当归四逆汤的基础上加了吴茱萸和生姜二味药。方剂中的生姜从量上看是半斤，折合成现在的重量是 125 克左右。吴茱萸是两升，也就是两个 200 毫升的容量。经过实测干燥的吴茱萸饮片一升的重量约等于 90 克，两升就是 180 克左右，折合成汉代的“两”是 11.5 两左右。由此看出这二味药虽然是在当归四逆汤的基础上加的，但它们的用量却远大于其他的几味药。

还有个小问题，吴茱萸为什么用升而没用两来计量？很可能在当时吴茱萸用鲜品的机会比较多，因为这种植物身边常能遇到，在合适的季节可以采摘到鲜品。这样一个是方便，且能省钱，所以针对这种情况用了容器来作计量，避免干品和鲜品之间含水份的多少造成秤重的误差。从量上看吴茱萸实际成了这方子的主药了，但是现在假如开方子用这么大的量，药店都不敢卖，实际现在也用不了这么多。这里细究还有一些小问题，有兴趣大家可以去思考：吴茱萸是一颗颗比绿豆稍小点，比小米稍大点的药，汉朝时大概也是这么用，就是原药放在锅里面熬，现在也是这么用。但是其它的比如当归、桂枝、芍药在汉朝都是很大块的，如果是这样的话，其他的药现在都已经做饮片做得非常小了，只有吴茱萸还是原来的样子，那是不是吴茱萸还应该用原来的量？这个值得去思索，也可以去试验。

通过对当归四逆加吴茱萸生姜汤与当归四逆汤两个方剂的药物变化，可以进一步加深对吴茱萸作用的认识。吴茱萸的药性跟干姜比较相似。把该方剂中的吴茱萸和四逆汤中的干姜做个比较，就很容易发现它们之间是有区别的，从这个区别中能够感悟到吴茱萸一些比较有特点的地方。通过刚才对药性的分析，可以知道吴茱萸的主要的作用是温里。但是其跟干姜比还得进一步细化，吴茱萸的温里主要是治疗消化道以内的虚寒证，并且可以治疗由这一类的病理引起的如头疼、头晕、烦躁等一系列的症状。但干姜就不同，用的面就宽很多，

不仅仅治疗里虚寒，也就是不仅局限在消化道里，同时还有亢奋人体机能方面的作用，而且包括一些半表半里的寒证，比如一些肺部的，后世叫肺寒的，就是因为虚寒造成咳喘这一类的病都能用，但是吴茱萸在这些方面的应用就非常少。所以这样就能明显看出吴茱萸主要是集中在治疗胃肠内的里虚寒证这一环节，而且治疗的疾病都有一些显著的特征，比如有明显的里虚寒同时伴有头疼或者头晕，确定是吴茱萸证的机会就比较多了。

下面看看当归四逆加吴茱萸生姜汤的方证。虽然该方剂没有当归四逆汤证应用的几率那么高，但在临床应用的机会也是比较多的。主要症状反应：四肢厥冷、少腹冷痛、周身疼痛、胃寒、四肢疼痛、恶心、呕吐、面色苍白、腹胀、腰膝酸软、皮肤瘀斑、月经量少、色暗有块。

舌质：主要有暗红、淡白，有的有瘀点，还有的是青紫；另外还有有齿痕的，有镜面舌的，有裂纹的，这个出现的几率都比较低一些。

舌苔：主要是白苔，另外还有厚腻苔，有燥苔、有黄苔，有少苔。

脉象：出现频率最高的是沉脉，其次是细脉、微脉、迟脉、涩脉、紧脉。

当归四逆加吴茱萸生姜汤的现代应用不细说了，统计里有几个当归四逆汤里没有出现过的：疝气，慢性阑尾炎，舞蹈病，牙疼。其他的跟当归四逆汤都比较接近，也没什么特别的。

大汗出、热不去、内拘急、四肢疼、又下利厥逆、而恶寒者、回逆汤主之、①（353）

注：《宋本》此处有四逆汤方及方后注，此从略。

胡希恕：这一个“大汗出”，啊，总是由于发汗大汗出，不是汗出不止。要是汗出不止，这一个，这一段呐，这是个死证。你们看看头前儿就知道了“伤寒六七日不利，便发热而利，其人汗出不止者死”。

还没有底下这些这个，啊，证候呢。那么这一个就是说是这一个，啊，“发汗，大汗出”。虽然大汗出而热不去，这就是精却邪胜了，啊，这一个，啊，这个“热”指着“邪”说的。由于这个大汗出，伤津液了，所以“内拘急”。这个“四肢疼”啊，就是阴寒的这个“四肢疼”，不是个表邪了。“又下利厥逆而恶寒者”，同时又有下利，啊，厥逆而又恶寒。既汗出又下利，这个津液亡失更厉害。所以津液亡失啊，他这个“内拘急”，就赶紧，这个“内”指着“腹内”，腹内呀，这个组织枯燥，有这个抽的现象“拘急”，这一个四肢疼啊，就是血瘀滞而…啊，所不通则痛嘛，他由于这个虚寒太厉害了，啊，血气瘀滞，那么种疼痛，不是表证。“又下利厥逆”，而一味“恶寒”，这是，纯粹是阴虚证候，所以只是用四逆汤救治，那么也…你看看这个地方啊，这个你们看看这各家注解都错了。这个津液这么样子虚竭，而用大温大热的药，那么这一个他就是救胃，恢复一分胃气，就能够维持一分生机呀。这个津液哪来的？由胃来的。胃气不复，这津液不会恢复的。所以这个时候啊，稍用这一种……（音频 037 完）（音频 038 始）……急以救胃不可，用一点寒药都不行，啊。所以他这个地方全是。他腹内拘急，啊，而四肢厥，那么这一个津液它是虚竭到家了，由于什么呢？就是大汗出，又下利。不能认为这个津液虚竭而来滋阴补液，那一来就坏了，啊！所以这个时候，啊，还要给吃这个生地呀、麦冬啊…他肾气虚呀！所以咱们在临床上，啊，常…滋阴么，这阴虚呀！阴虚你看他证候啊。他真是这个人身上机能到衰竭之候了，那你是一吃就死。你这个…这个书啊，啊，所以咱们遇着这个，在临床上也常遇着这个事儿啊，就咱们这医院也有这个事儿啊，那人呐，已经到最后了，虚竭到家了，还用独参汤呢，那不行啊。那非附子，非大力附子干姜不可。你看看通脉四逆汤，他就把这个四逆汤又把附子干姜增量啊！他不搁人参，人参它微寒呐！所以咱们拿那个独参汤…我，我这些年我看到了，没救过活的一个，吃来吃去就完蛋了。它那不是，

啊，救这种这个，啊，肢厥、津虚，它治不了。非是这个附子、干姜这类药不可，与甘草配合。这个地方啊，咱们…啊，学他这个书啊，要注意。这很容易犯的病，尤其后世搞…啊，搞这个，啊，这个六味地黄汤搞惯了，遇着津液虚就来…那准是，那误人呐。可是真正有热，啊，虚热的那一种情况津液虚，那你用六味…啊，六味地黄太对了。没有热，啊，一片虚寒，这一个津液虚你还给吃，什么意思啊？这个地方很重要，很重要的。

李冠杰：这条在《康平本》里是降二字格排版的条文。《宋本》在该条文后附有四逆汤方剂和方后注解，《康平本》里没有。

下边解读一下：

“大汗出”，这里是由于发汗太过所致。虽然该条文没有论述发汗的过程，但是有个“热不去”，这个“热不去”本身就暗含有热且经过治疗后有汗出，但是热不得去的这样一层意思。所以这里应该是使用了发汗解表的方法治疗后，造成了这种“大汗出、热反不去”的情况。由此可见原本虽然有发热但不是表证，至少不是表实证，所以此处的发汗就是误治。造成的后果就是“内拘急，四肢痛”，这是由于汗出太过，造成人体津液在短时间内虚损严重，致使组织器官失养的一种反应。所谓“内拘急”指的就是腹腔内的器官发生抽搐的状态，这说明体液虚损的情况已经非常严重。“四肢疼痛”可以理解成“四肢拘急”的一个重症，也就是本来津液虚损轻的时候是四肢拘急，但此时拘急的症状已经过了，就发展成了疼痛。

“又下利，厥逆而恶寒者”，这是典型的阴性里虚寒证的反应。服发汗药之前还没有这些症状，而从发汗后才出现的这些症状推测，这里的“大汗出”应该是在既没有表实证又没有里热证的情况下，误用了大青龙汤这类方剂所造成的不良后果。因为有一些比较典型的医案（条文里也有）就记载过服了大青龙汤之后，有出了人命的，有出现一些不良后果的，那么就需要用四逆汤来治。

该条文必是来自于临床实践，可以理解成这是该作者临床取效的经验，他用四逆汤治好过这一类误治的后果。但是该条文既然出现在厥阴篇中，但又不是厥阴证，这里就有警示读者的意思：不要把所有的厥逆证都视为厥阴病，也有上述这类情况出现了厥逆证的，这是四逆汤证而不是厥阴病。可以再去看看其他条文，前边学习时已再三强调在这类条文作者的理论知识里，厥阴病和厥逆证是相同性质的问题，但该条文等于是在用事实说明并不是所有的厥逆证都是厥阴病，澄清了这个问题的另一个方面。

大汗、若大下利、而厥冷者、回逆汤主之、（354）

胡希恕：“大汗，大下利”就是津液脱…津液欲脱啊，是吧？那么他一定要厥冷。这也只是有四逆汤这一法。这地方都挺好，他这也是着重这几点，在这块儿反复这么说，啊。这就是，啊…怕是你这个，啊，这个滋阴这个说法，这就是，……这赵献可以首开其端呐，啊，张景岳这是促其大成，他净搞这些东西。但是他也有道理，也有道理他是…就是得有真正的是虚热证候，津液虚，是用那个；不是说是津液虚，就得那么来，啊。

李冠杰：这条在《康平本》里是降一字格排版的条文。

“大汗，若大下利而厥逆者”，这是三个可以互相佐证的症状。当“大汗”同时伴有“大下利而厥冷”时，说明此时的“大汗”属于在阴性里虚寒证的情况下发生的脱汗。当“大下利”与“大汗”和“厥冷”同时出现时，则说明此时的下利是一个阴性里虚寒重症的症状反应。当“厥冷”跟“大汗”和“大下利”同时出现时，说明这个厥逆证为阴性里虚寒所致。

假如该条文里的三个症状中的任何一个单独出现，那它的病理至少都有两种可能，或者是里虚寒证，或者是里热证都可能造成这样的症状，但是当三个症状同时出现时，立即就可以排除因为里热造成的

情况。比如大汗的症状，里热可以出现；大下利也有可能，像白头翁汤证之类的，但是再一出现厥逆，它就不是热证了；其他的都一样，所以这三个症状有互相佐证的作用。实际上这是经方辨证一个非常重要的内容，也就是讲究整体综合地分析人体的疾病状态。

具体到该条文，大汗和大下利可使人体的津液大量损失，而且厥逆证又说明人体已经进入了机能沉衰的阴性证阶段，所以此时用四逆汤这一类的方剂是比较合理的。

在这一点上说几句题外话，经方辨证这一点非常重要，任何一个单独的脉象、单独的症状，或者一个单独的其他病理因素都不能构成用方的依据和某个方证，而且所有的方证都是由一个动态的症状群组合而成的。换句话说，仅凭一个症状用药常常是不准的，用药遣方要讲究整体，认为是虚寒证就必须得有别的症状来佐证，仅一个脉象或一个症状是不足的。

病人手足厥冷、脉乍紧者、邪结在胸中、心下满而烦、饥不能食者、病在胸中、当须吐之、宜瓜蒂散、

①（355）

注：《宋本》此处有瓜蒂散方及方后注，此从略。

胡希恕：这个“手足厥冷”啊，啊，有实有虚，有寒有热。头前儿“寒热”都说了。那么这一个它说有一种这个，啊，“胸中实”也能使之“手足厥冷”。“脉乍紧者”，这个“紧脉”是个实脉。你看看我们说这个太阳伤寒，脉紧，就是实于表，叫表实证。有宿食，啊，脉沉紧，就是胃里头实；或者是，啊，有宿食的病他脉也紧。这个“紧”是一个“实”，实候。那么这病人“手足厥冷”，脉伶仃紧起来了，那说明里头有…有实。“实”就是虚实的实了。那个这个“实”在哪儿呢？“邪结在胸中”。所以“心下部满而烦”，啊，他是往上冲逆。咱们这个瓜蒂散证头前儿也讲过了，啊。他说气上，啊，冲胸咽么，

心中愠愠欲吐，他这个“心下满而烦”，就说明这些问题。这个“烦”是“烦逆”，啊。“饥不能食者”，他这一个不是虚寒呐，啊。他能…想吃，但是吃不了，一吃他要吐，它往上来。所以这就是看出中医这个治病啊，他是顺应这个机体这个，啊，这个机制的，这个病，这个里证就是这样子，他就利用这个消化道啊，或者吐出去，或者泻下。那么这一个就是欲吐而不能吐，所以这个邪气是满于胸中，这个脉紧。那就是顺其势而吐之就好了嘛。所以“当须吐之”，啊，用瓜蒂散。这地方都好，啊。这个就是，那么这一个，啊，顺应这个病的病机了。所以，这个书里头也有啊，病欲吐，病欲呕者，不可下，下之则死。他这个病机，本来他打算吐出去好的病，你反到给下之，那非死不可。所以这个临床啊，非要是这个详慎不可，冒冒失失的来了就不行。那么这个吐本来有用下剂的机会，你像大柴胡汤，啊，呕不止嘛，他那个“呕不止”啊，是病之所在。这一个是，你看这个瓜蒂散证，他是心中愠愠欲吐，这个病啊，是往上逆得很，而复不能吐，他吐不出来。所以这个辨证啊，那不到…啊，非细不可，不然的话弄错了，弄错了就危险，啊。所以他这一段，他没像头前儿说那么详细，他就搁个“心下满而烦”，这个“心下满而烦”包括很多的问题呀，“心下满”怎么？它从底下往上来，他腹是不满的，他往上来，这个邪气是贯于胸中，他说病在胸中，啊，那么胸里头那是烦满，那么这一个烦呢，不是一个“烦热之烦”，它是“烦逆之烦”，要吐不能吐这么一种烦。所以瓜蒂散证也可以治四肢厥冷，所以这个四肢厥冷啊，是各式各样的。那么，可见他是泛论厥呀，不是只是论的厥阴病啊，啊。所以把这个也搁到厥阴病里头这不糟糕了吗？厥阴病还有瓜蒂散证，啊，那不是不对了嘛？又有白虎汤证，啊，又有，啊，通脉四逆，也有乌梅丸证，嘿，这一段呢，这个厥阴病你怎么掌握啊，所以他不是的。

李冠杰：这条在《康平本》是降一字格排版的条文。《宋本》在条文后附有瓜蒂散方和方后注解，《康平本》没有。

下边解读一下：

该条文论述的是瓜蒂散证的另一种表现形式。在经方理论中关于瓜蒂散证的论述一共有三处，在《伤寒论》里就是第 166 条和本条，在《金匱要略》中还有一处但那是附方，所以严格地讲可以把它算在经方理论之外。因此也就只有《伤寒论》中的两个条文是原书里的内容，而且这两个条文在《康平本》中都是降一字格排版的。在第 166 条中论述的瓜蒂散证是一种近似于桂枝汤证的样子，但是头不痛、项不强，同时又表现为胸中痞硬气上冲咽喉、不得息等一类的症状反应，这是一种情况。该条论述的是则另一种情况，患者表现为“手足逆冷，脉乍紧”，这应该是瓜蒂散证又一种典型的症状反应形式。从临床统计资料看，瓜蒂散证确实有四肢不温的症状出现，但是出现的频率并不是特别高。

“脉紧”，作者的本意就是说这是一种实证，所以应之于脉应该也是一种实脉，说明人体此时有内结实的情况。

“邪在胸中”，这句话在该条文中既是这个方证的病理解释，又有承上启下的作用。一方面阐明了“病人手足逆冷，脉乍紧”是胸中结实的证候；另一方面说明后面的述症也属于邪结在胸中这种病理。

“心下满而烦”，这个“心下满”指的是胃中满，但这个“烦”却不能理解成一般的烦躁。因为在有应用瓜蒂散治愈机会的现代病中包括：神经衰弱、癔病、癫痫、癲狂病、神经分裂症、痰厥不语等这类精神方面的疾病。所以此处的“心下满而烦”应该指的是胃中满甚至到了愠愠欲吐的情况，与此同时还伴有精神方面的一些症状反应，而不是单独“心烦”的那种“烦”。当然假如精神方面的疾病轻微，也可能仅会表现为烦躁不安这类的症状反应，但是它跟其他的烦不一样，因为它有往纵深发展的趋势，直接可以造成精神分裂症，但是其他的烦常常到不了这种程度。

“病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散”，这既是对瓜蒂散证做出病

理定性，同时又给出了治疗原则和具体治疗方剂。

此处我突然想到一个问题，之所以瓜蒂散证需要用吐的方法来治疗，这到底是一个怎样的病？病理上到底是什么样的机制？后来查了一些相关资料，我认为对这类问题只能客观地、现实地看，关于瓜蒂散证的发病机理到目前为止现代的研究也没有实质性的突破。比如这到底是种什么样的疾病？为什么一定要用吐法才可以治愈？吐又解决了人体什么样的问题？这些始终没有令人满意的解释。我们只能从经方理论角度认识这个方证，当人体表现为该方证时、在临床中表现为这种症状时，就说明人体处于一种半表半里的实热证和里实热证的病理状态下，并且人体形成了一种以涌吐的方式自人体的上部排除疾病的趋势，而瓜蒂散恰恰具有催吐的作用。

瓜蒂散在经方中也不仅是单独用来催吐，比如通过鼻腔给药还可以治疗其他的疾病。例如肝脏方面的疾病，还可以治疗黄疸这类的疾病，说明它还有其他的药物作用，但是在治疗瓜蒂散证时却是用其单纯的涌吐作用。因为吐完以后这个药就不能再连续吃了，只要是吐了就不能再给药了，说明就是用它起到一个吐的作用，它并不能直接祛病，人体有以涌吐的方式祛病的趋势，只是帮助人体达到这个目的而本身不具祛病的作用，假如要是祛病的话完全可以再吃两天巩固巩固，这是现在常说的。另外人体凡是欲用涌吐的方式解除的这类疾病到底是什么病，为什么会造成精神方面的问题，甚至出现一些精神方面的疾病？至今没有令人满意的答案。

伤寒厥而心下悸、宜先治水、当服茯苓甘草汤、却治其厥、不尔、水渍入胃、必作利也、①（356）

注：《宋本》此处有“茯苓甘草汤”五字，并有方及方后注，此从略。

胡希恕：这还有一种厥。“伤寒”也指着太阳伤寒，“厥”四肢厥冷。所以这四肢厥冷是一个证候啊，你要变了，变了你…他“心下

悸”。“心下悸”这是有水之证候啊。这个《金匱》上有，啊，在痰饮篇里头，所以人呐，啊，饮水多，那么水停心下，甚者则悸，微者短气。所以胃要停饮呐，这个水在这块儿多，这个心下，啊，这个非心下悸不可，跳；那么水少呢？短气。所以咱们遇着“短气”呀，那不定，不一定就得补啊，那是有水，也短气。这就得整个辨证了，啊。那么这一个“厥而心下悸”，肯定这里头有水，哪有水？胃有水。所以“先治水”，宜先治水。用什么药呢？偏于治心下悸的药吧，又得去水，他用茯苓甘草汤。你看看茯苓甘草汤这个药，它以桂枝甘草为基础的，这个桂枝甘草汤咱们讲过了在太阳篇里头，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。这个桂枝它是治气上冲，这个气往上冲逆，啊，如果再有其它的问题，他这个心下跳得非常凶，不然的话，桂枝甘草汤也治心下悸呀！又有水，他得搁茯苓，这个水在胃，他搁生姜。这个生姜，这是个健胃的药，啊，那么当然是，这个病啊，也有呕逆的现象。他…他没说明，他，这仲景这一个，把这个主要症状说了，只是说个“心下悸”，这个可有可无的证状他就不说了。据这个方剂这四味药上说，应该有呕，气冲欲呕，心下悸。因为这个水专门儿在胃里头呢。所以在这一个呀，如果我们遇着这个“伤寒四肢厥”，要有“心下悸”的话，这个“心下悸”底下应该有个“者”字儿，你看看这个，后边他注的，《玉函》就有个“者”字儿，也就是“伤寒厥而心下悸者”，这一类的厥。我们应该添个“者”字，因为有个“者”字，这个语气才完…完足。那么这一个，你不要把这个厥，啊，也不是热厥，也不是寒厥，就是有水，“当先治水”。用什么药呢？用这个茯苓甘草汤。“却治其厥”呀，然后再治厥。虽然是说是然后再治厥呀，也就是治水就所以治厥，不是然后再治厥了，他这，啊。要假设不这么治的话，那么“水渍入胃”，水老在那个胃里头泡着，必作利也，不但，不但厥而且马上就是既厥又利，那病就是深入了，啊！所以别等他作利，你就用茯苓甘草汤，不但水能治，厥也必治啊。这言外里

就是啊，他这书上没这么说。这个方子要是，啊，我们遇着这个方子，也可以，就会用药了。如果这个胃有停水，你这个停水就得去水，当然就得用利，啊，祛水利尿的药了。这个配伍这个药啊，要是胃有水，你要配合生姜，胃有水准要用的，啊。那么他冲逆的厉害，到心下悸，你配合甘草汤，桂枝甘草汤。所以这个地方啊，对这药物的配伍，也得在这上慢慢来认识。我们在临床上，啊，这个加减呐，你怎么加减呐？啊。根据这个古人这个方子，你看他怎么用药？长了你自然就会了。

李冠杰：这条在《康平本》里是降一字格排版的条文。在《宋本》里条文最后有“茯苓甘草汤”五个字并附有方剂和方后注，《康平本》里没有。

下边解读一下：

“伤寒”在该条文中应该理解为有表证的意思。从茯苓甘草汤的方药和临床应用看，该方剂解表的力量还是比较强的，里边既有桂枝又有生姜。但因为有水证的因素存在，实际上也就是一个表虚证，但是汗出的症状不像桂枝汤那样明显。另外还有个问题得弄清，即使没有汗，也不应该有表实证的倾向，不应该是表实证；一旦有表实证那就是另外的方剂了，比如小青龙汤或者麻黄附子细辛汤之类的。

“厥而心下悸”，指的既有四肢厥逆又有胃部跳动的感觉。“心下悸”就是指的胃部跳动感。从病理角度分析，该方证中的“四肢厥逆”既不是里虚寒证造成的，也不是里热太甚造成的，而是在胃部停饮的同时又伴有气上冲的情况，在这种情况下出现的一种厥逆证。“心下悸”是胃中停饮的一种特征性的症状反应，这个症状在临床中是更容易找到的。只要做腹诊让患者平躺，然后把手放在胃或者肚脐以上的部位，跳得轻的手稍微用一点力，就能感觉里边在跳；跳得重的只要把手放上就感觉在跳，我在病例上曾经就这么写：心下跳动剧烈。那就很明显，而且不仅能摸到，摸的同时问病人，这个地方跳你知道

吗？他说你一按我现在感觉到了。有的人每天睡觉时摸这个地方就知道在跳，跳的频率与心脏是同步的。对这种症状现代医学的认识从中医来看挺可笑的，认为是腹动脉跳动引起的，那么大多数没有“心下悸”这种跳动的人作何解释？换句话说，现代医学对这种病的病理一无所知，不知道人为什么会出现这种情况，但在经方里这是一个常见症状，也是一个特色症状。

还有一个问题，虽然胃中停饮的方证很多，比如吴茱萸汤、理中汤、五苓散、泽泻汤等都有这方面的因素，但却不是所有的胃中停饮的方证都有“心下悸”的症状出现。这个症状跟茯苓、桂枝两味药的关系比较密切，它们常表现为一个对应关系。比如桂枝茯苓丸证出现这种症状的几率比较高，但也不是每个患者必定会出现；肾气丸证出现这种症状的几率也比较高；再就是茯苓甘草汤，这三个方剂里全有茯苓和桂枝。所以我们就根据药物的作用来推测病理，就是在胃中停饮的同时又有气上冲的病理条件下发生的一个特殊症状。

“宜先治水”，明确阐明了该方证的病理，而且还论述了此种情况下水证是主要的病理矛盾。在经方理论里水证的病理因素多数情况下要比其他类型疾病的病理因素要重要，除了四逆汤、通脉四逆汤这类的危重病之外，用现代的描述方式来讲，只要有水证存在，在治疗排序上就常会被列入到优先的位置。比如桂枝茯苓丸，一般在临床中常没有典型水证的症状表现，但是里边却有茯苓，说明水证不重但有这方面的因素，必须得把这个因素考虑在内。实际上水在人体中占得分量挺重，作用也非常重要，有点像空气。其实人一刻也离不了空气，离了就死了，但因为空气来得太容易，所以没有人珍惜它，也没有人把它看得多重。其实水也一样，从经方中就能看出来，经方的许多方剂里都有治水的药，比如治津液虚的，治停饮的，都是在调理人体的体液代谢。体液代谢不正常，很多其他的疾病是治愈不了的。

“当服茯苓甘草汤，却治其厥”在条文的本意上，有先服茯苓甘

草汤使水证得去，如果厥逆证仍然存在，可再进行辨证施治，以其他合适的方剂来治疗厥逆证。这里的“却”应该当做“再”的意思理解。这在临床实践中包括了两种情况：一类是服了茯苓甘草汤之后水证去了，厥逆证也随之消失了；另一类是水证去了，但厥逆证仍然存在。这就涉及了茯苓甘草汤证中到底有没有厥逆证的问题，从临床统计资料看，该方证中确实有这一类的症状。所以服了茯苓甘草汤后厥逆证要是好了，那就没必要再提了。但是有些病理因素比较复杂的患者也可能水证去了，但还存在厥逆证，此时就可再去治疗，符合什么方证就去治疗什么就行了。

“不尔，水渍入胃，必作利也”，这里论述了上述情况下必须先治水证，把这个重要性又再次强调，假如不按照此原则去治疗，就有可能出现不良后果。但是这有个问题，此处的“水渍入胃”是古人通过临床观察对于这种“心下悸”治疗不当发展成下利所作的一种发病机理方面的解释，包含了认为此时的“饮”是在胃之外的意思。但事实上“心下悸”本身就是胃中停饮的一种反应，只是此时如果用其他方剂先治厥逆证的话，常会加重胃中停饮的病情，最后会出现下利的情况。所以古人观察后做了个总结，如果那样治疗以后胃虚了，水就跑到胃里去了，实际上不是这样。临床中这类情况如果治错了，大概出现下利以后，心下悸的情况就消失了，根本没有气上冲的趋势了。古人通过观察这个现象，认为水原本在胃外，误治造成胃虚后水跑到胃里去了，所以才下利。实际上现在看就是误治以后造成里虚，本来里面就有停饮，停饮的情况就会更加严重，造成了水走肠间的情况。

做个小结：患伤寒后出现厥逆和心下悸的，适宜先治其水证，应该服茯苓甘草汤，而后再治疗其厥证，否则先治厥证则可能加重胃中停饮而造成下利。

关于茯苓甘草汤的临床统计资料在学习第 73 条时已经讨论了，这里就不多说了。茯苓甘草汤在临床中也是个常用方剂，应先从病理

上理解透，其既有表虚证又有水证，具体还表现为有气上冲。此外胃中停饮这是具体的，从中医的角度能在病理上确定它的病理机制，但在实际临床中这种病理还可以造成一些其他的疾病。比如胡老的经验，加上龙骨、牡蛎后可以治顽固性失眠，这个顽固性失眠得具备这个病理特征，只要是具备这种病理特征的用这个方子确实非常管用，用别的办法还真治不了，用它以后就好得非常快。

大家去感悟一下这个病理，气上冲和胃中停饮结合到一块儿，影响到了人的精神方面。这个地方不仅是一个表现为，用手摸上去一跳一跳的，对人的生理还有更深层的影响。另外，临床中有表虚证又有停饮的吃这个药也没问题，但是跟苓桂术甘汤和苓桂枣甘汤相比较还是有一定差距，这个都比较好鉴别。

伤寒六七日、大下后、脉沉而迟、寸·手足厥逆、与回逆汤、下部脉不至、咽喉不利、唾脓血、泄利不止者、为难治·属麻黄升麻汤、（357）

注：《宋本》此条文如下：

伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，咽喉不利，唾脓血，泄利不止者，为难治，麻黄升麻汤主之。

麻黄二两半去节 升麻一两一分 当归一两一分 知母十八铢 黄芩十八铢 萎蕤十八铢一作菖蒲 芍药六铢 天门冬六铢天心① 桂枝六铢去皮 茯苓六铢 甘草六铢炙 石膏六铢碎绵裹 白术六铢 干姜六铢

注：“天心”《宋本》作“去心”。

右十四味、以水一斗、先煮麻黄一两沸、去上沫、内诸药、煮取三升、去滓、分温三服、相去如炊三斗米顷、令尽、

汗出愈、

胡希恕：还有一段，这一段成问题的，啊。这一段据我看它是准有错误。“伤寒六七日”，五六日是传半表半里的时间，到“六七日”呢，就是由半表半里又要传里的时间了。“大下后”，啊，这就是吃这个大泻药之后发生的这些问题。“寸脉沉而迟”，就这个，啊，这个寸脉不是，啊，就是指的这个寸口了，就是这寸部了，又沉又迟，沉为在里，迟为有寒了，啊。“手足厥逆”，啊，这是一个，咱们头前儿也讲了，这是虚其胃，啊，津液也虚，大下嘛，所以“手足厥逆”。“下部脉不至”，这说尺，尺没有脉了，这是，尤其下虚的更厉害了。“咽喉不利”应该“咽喉不利”，这个《玉函经》它是咽喉不利，就说的这个。“咽喉不利”也能讲啊，所以这个改不改都没关系。“咽喉不利”，啊，他是有咳逆上气的情形了。“唾脓血”，唾脓血是什么呢？又咽喉不利，这肯定是肺病了。你们看看那个…啊…《金匱要略》肺痿肺痈那一篇，他这么讲的，他说无论发汗或者利小便，或者以快药下之，即亡津液。亡津液，这个热它光在里头他也不至于让他吐脓血的，如果丧失津液了，啊，热再陷于肺，那非…非伤津而吐脓血不可，这是《金匱要略》上说的。你们回去看看那个，啊…肺痿肺痈就知道了。那么这一个说呢，大下之后，啊，就脉上来看，这是津液虚的不得了，甚至于下部脉不至，下又虚，可是呢，这热可陷于肺了，而为这个吐脓血的这个肺痈这一类的病。同时又是“泻利不止”，他这个下部脉不至啊，啊！就是应这个下，泻利下不…下，啊，而不止。这个肠胃也是虚的不得了了。他又个大下之，“为难治”，这一个这是一个…这个病非常的寒热虚实错杂了，又有热，又有虚，啊，这个病很不好治啊！但是他底下说个什么呢？又用麻黄升麻汤主之。这个不像仲景的话。既是难治，可以“与麻黄升麻汤”这还行，要说它“主之”这很成问题了。他要说是主之，就不能说是难治。而且我们再就这个药来观察，这个药它以麻黄，啊，麻黄为主，发汗。

我们看看这个病可不可以发汗？绝不可发汗。那么无论就这个肺痈，啊，他是肺痈有热，或者就这个下利不止，这一个他这个书里头啊，尤其在这个《金匱》上有明文，啊，他说是这个渴…渴而下利，都不可发汗。渴，津液虚；下利也是丧失津液，没有下利，啊，下利没有，要有表证可以发汗，用葛根汤啊，啊；没有表证，你发那门子汗呐？我们这一段呢，你们看看有表证吗？没有啊。他脉沉而迟，这是寸口。同时手足又厥冷，那虚的够…够可以了。尤其他泻利不止，怎么能吃麻黄呢？以麻黄为主，还发汗呢？我这个…恐怕这里头有问题，啊。我没…我在这个注解里头把这个也作为疑问，没注解。那么各家也就是随便说了，啊。那么其它的药我认为还没…我认为没有用麻黄的这个可能。由于他这一个，啊，这个就是去热搁石膏，看石膏搁多点儿？搁 6 铢。24 铢是一两，一两要三副，合现在，一两是三钱呐，啊，一两就是一钱呐，三副药啊。三，啊，他这分三服嘛，一钱，24 铢才一钱，6 铢你想多点儿？搁那点石膏有什么用啊？这个麻黄用得相当重，2 两半。它这个配伍的法子，也不像张仲景的这个方子。而且这个，这一，这么一种的厥阴，啊，那么即便有阴阳错杂，寒热并见，也没有再发汗之理。我认为这一个，这是有错误。可是各家都这么样子，随便这么说。我没…我这个，这一…这一段呐，留作参考吧，啊。我看看这个治疗这成问题的，这个头前儿这语气也不对，他既说是难治，还有个主治方儿，没这个话。这口气也不对。今天咱就讲到这儿，啊。这一段呐，大家作为一个研究，你们看一看，是应该用这个药嘛？是吧。我看是不行。没有发汗的条件，而且还真正就发汗，这个成问题的，啊，啊…所以这个我认为…他这个书啊，它以前净是传抄。怎么搞的也不知…这个总是有旁处…弄…弄错了。“为难治”我认为就完了，不应该再有，啊，麻黄升麻汤主之。这不知来哪上这么一段，他搁这里边了。那么这个病大下之后有这一种情况，啊，这是阴阳错杂，寒热并见，而且有了肺痈了，这很难治一个病。

到这儿我认为就完了，他底下又弄一个麻黄生麻汤主之，还有，真有这个方子。这一个不定在哪个地方。我认为这个成问题的，啊。一个人的见识不一定就对，你们也考虑考虑，看看旁的书。我看不少，因为这一段呐，我翻了各家书我翻有二十几种，啊，调解注明的，没有一个说得像个样子。

这个厥咱们讲完了，啊，下次咱们讲这个下利…呕哕他讲得也少，下利讲得倒不少，下利可以把这个，啊…下一次下利总可以讲完。

李冠杰：这条在《康平本》里是降一字格排版的条文。在《宋本》里因为把旁注内容篡入了正文，同时又把正文的最后一句做了改动，所以变成了：“伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，咽喉不利，唾脓血，泄利不止者，为难治。麻黄升麻汤主之”，明显和《康平本》的原文不一样。下边解读一下：

该条文有不少的问题。“伤寒六七日，大下后”在条文里包含了好几方面的含义。首先此处的“伤寒”不但是指最初的疾病为太阳表实证，从后边的论述也能看出来，同时经过了迁延数日不愈和误治以后，阳性表实证的病理因素依然存在，表证一直没去。虽然是误治，且误治后又出现了一些新的变证，但从最终的治疗方剂看，表证始终是一个很重要的病理因素，其始终存在。“六七日”指的是表证已经过了多日没得到缓解，此处至少能说明两方面的问题：一方面，是表证的病情比较重，否则经过六七天的时间假如病不重的话，此时一般人就可以自愈了；另一方面，说明人体的抗病能力也比较强，假如抗病能力不强的话，按照经方的规律在六七天之前就应该发展为其他类型的疾病了，就是所谓的“传里”，实际上也不是传。在临床医案中也确实有记载，这类病人的体质都比较健壮，确实有这样的案例能佐证这个问题。

那么这样其后的“大下”出现了一种很特殊的症状，但就是没有出现阴性证。这就不难理解了，因为得的表证就重，人的抗病能力还

比较强。这里具体还有个误治因素，假如没有误治，如果出现那种病也需要用这方子来治。看看后边的方药，实际上这里有点像那种比较重的流行性疾病。“大下”肯定就是误治了，表证施以下法本身就是误治，何况患者的表证已经过了六七天了，六七天指的是天数已经比较多了，经过这么多天不愈，此时再用“大下”的方法必然会造成新的变证。

所以出现了“脉沉而迟，手足厥逆”的症状，这是对上述“大下”后出现的最主要的、表现最突出的新变证的述症。这个症状初看时，会判断为典型的里虚寒证，但再往后看条文用四逆汤没治好，不效。再去看看最终治疗该疾病的方剂就明白了，这里“脉沉而迟，手足厥逆”的病理是因为大下后造成的里虚证，主要是里虚、胃肠吸收能量的作用低下，致使人体能量供应不足才造成这种情况。在这儿虽然不排除有里寒的因素存在，但此时的里虚绝对是个主要病理矛盾，同时还有里热证夹杂在里边，所以这个时候用四逆汤是治不好的，虽然看着症状表现特别像，但跟四逆汤在病理上对不上。实际正因为如此，所以当时的医者就用了四逆汤，要是从“脉沉而迟，手足厥逆”之前的论述看，这个时候用四逆汤不错，但是吃了四逆汤后几乎没什么疗效，这里边就另有原因了，就需要再回头细辨一下病人，他还有别的症状。

这里再顺便提一下旁注的“寸”，在《宋本》里篡入正文是犯了一个低级错误。一是原文的作者没有这层意思；二是“寸”本身跟病理也不合拍。另外还有一个“迟”字，“迟”跟“寸”是不能在一块出现的，只要是表现为迟也好、数也好，整个脉都是这样子的，单独一个“寸”表现“迟”，哪有这种可能性？所以这个字在这里篡入正文就更错了，本身加这个字就是不对的，而且从病理上看还有表不解的因素存在，一般也不会出现寸脉沉的情况。

接下来“与四逆汤，下部脉不至”，下部脉指的就是尺脉。患者

服了四逆汤后不单单症状没有根本改变，而且尺脉仍然不至，这里的原意可以理解为寸关脉可能稍有好转，但尺脉至少是维持以前的样子。也就是服了四逆汤后里虚证的症状并没有改善，言外之意就是方不对证。此处不是四逆汤证，虽然起初是表证，后来误下后又出现“脉沉而迟”再加上“四肢厥逆”，这个时候看似是四逆汤证，可是服四逆汤没有治好，甚至没有向愈的趋势，所以必定还有四逆汤之外的一些病理因素。

接下来就有“咽喉不利，唾脓血，泻利不止”这些症状的出现，与服四逆汤没有直接的因果关系。这些症状大概是在服四逆汤之前或者在服的过程中就有了，只是此时的患者并不是四逆汤证，所以服了四逆汤后这类的症状并没有解除，回头看看患者还有这些症状表现。

“咽喉不利”指的是咽喉肿痛、吞咽不利的症状。“咽喉不利，唾脓血”都是热证的症状反应。而“泻利不止”从后边的方剂可以看出这是里虚证的症状反应，因为方与证不相应，所以即使服过四逆汤下利的症状也没有得到缓解。事实上虽然服过四逆汤了，这个时候的厥逆证会不会好，那也不一定。因为该方证在临床中确实有四肢厥逆的症状出现，当然不一定有误治的过程，但是在该方证里存在出现这个症状的机会。

整体解读该条文的论述可知这是一种寒热错杂、表里同病，但还没有进入阴证的特殊的病理状态。其实按病情早就该陷于阴证了，但恰恰这里就找不到，看着症状也像，但是用治阴证的办法治不了，用四逆汤不行。

旁注“为难治”说明不了问题，只能说明在当时的历史条件下该条文论述的情况是一种疑难病，今天历经将近两千年的临床实践后这个方证也不是一个常见病。

“属麻黄升麻汤”在《宋本》里改作“麻黄升麻汤主之”，再加上把旁注“为难治”篡入到正文，使该条文在学术态度比较严谨的学

者眼里就变得不可理解了。既然是“为难治”又何来主之？胡老也提出过这个问题，而现在通过对《康平本》的解读把旁注内容剔除出去，使条文的本来面目还原以后，条文论述的内容还是比较清晰的。

但是这里又出现了一个新的问题，就是“属麻黄升麻汤”这种论述在经方理论中仅此一处，其中的原因有待进一步研究，现在没法作一个明确的定论，因为没有任何依据。但是通过后世临床应用的医案看，麻黄升麻汤治疗的疾病的反应与条文的论述非常相似，而且症状反应也非常集中，下面讨论方证的时候也会说到这层意思。它的症状反应非常集中，而不像其他的这边出一个用这个方剂的医案是表现这样一组证候，而另一个人治用的这个方剂是另外一组症状，那就得考虑这个方剂的加减，加减的多了以后就把原本的症状削弱了，但现在不是那样，一看就能知道。也就是说既然这个方子也能治疗该条文里的述症，但为什么偏偏用了“属麻黄升麻汤”这样一种特殊的句式，目前存疑。

麻黄升麻汤证的病理：表实证合并里虚、里热证合并半表半里虚热证合并水虚证合并血虚证。比较复杂，实际上这里也可以放一个里虚寒证，因为从药物上看既有干姜也有石膏，那是不是在里这一层本身就有寒热错杂的情况？这种情况一般不是很多。像这类的方剂实际没必要追究那么细，再去看方证，病理上不太恰当的地方可以在方证上解决。

做个小结：患伤寒已经六七天的时间，医者反以峻猛泻下的方剂治疗而出现脉沉而迟，手足厥逆，因此又以四逆汤治疗，反而下部脉不至，同时还表现为“咽喉不利、唾脓血、泄利不止者”的，属于麻黄升麻汤证。

下面看看方剂，麻黄升麻汤由十四味中药组成：麻黄、升麻、当归、知母、黄芩、葳蕤、芍药、天门冬、桂枝、茯苓、甘草、石膏、白术、干姜。该方子大部分的药物在以前的方剂中都出现过，我们差

不多都了解，只有升麻、葳蕤和天门冬是这个方剂中特有的药物。需要说明一点，这三味药物按照《药典》都是性平，但我觉得它们既然都有清热解毒之类的作用，那它们实际上就是偏于寒性，只是这种偏寒和其他一些典型的寒性药物，比如石膏、滑石、知母相比寒性没有那么大。另外《药典》里论述中药的味，在经方里没有太大用。把药性中没用的内容全都剔除，剩下凡能确定的就尽可能确定下来，所以药性的寒温属性就比较重要。升麻是一味偏于寒性清热解毒的药物，有解百毒、瘟疫、瘴气、风肿诸毒，头痛寒热、利咽喉这类的作用。方剂中加了这味药，说明其对应的疾病里就有刚才说的流行病这一类的，而且从治疗的现代病里有猩红热也说明是这一类的东西。葳蕤就是玉竹，也是偏于寒性的，有生津润燥、养血、润颜和补益作用。天门冬也偏于寒性，天门冬的药性实际上跟麦门冬有比较相似的地方，有清热润燥、生津止渴及一定的补益作用。

该方子的药物组成就比较复杂了，既有解表的麻黄、桂枝，又有清热的石膏、知母，还有清半表半里之热的黄芩，也有清热润燥补虚的天门冬、葳蕤，以及补血虚的当归、芍药，更有祛饮的茯苓、白术。干姜在方剂中主要作用是温中补虚；升麻在方剂中可以增加清热解毒的作用。由此可以看出该方剂的适应证也是一个比较复杂的情况，这实际上是一种因为久患表证不愈，或者误治或者未经误治或者患时疫性的疾病，致使人体陷于诸虚（不是一个方面虚，许多药物都有补益作用）的同时，但却没有形成阴性证的状态。这个很特殊，各方面都虚了，但是没有陷入阴证。

因为这个方剂有争议，我们得尽可能把它弄清楚。从方证上看，该方剂一共搜集到了六个医案，症状反应：便溏的 4 例，吐脓血 4 例、发热 4 例、恶寒 3 例、头痛 3 例、腰痛 3 例、腹痛 3 例、厥逆 3 例。其特点就是六个医案的临床表现几乎没有多大差别，症状反应非常集中，这是其一；其二，该条文的这些述症在临床中几乎都有，像

咽痛、吐脓血、便溏；发热恶寒、头痛，这是表证；厥逆也有 3 例，按比例占 50% 了。所以从这可以佐证一个问题：条文论述的这种疾病该方剂应该能治，也就是说症状反应这么集中不是一个偶然的问题。另外还有一个问题，统计这些数据的书上其它的方证都有对方子药物加减的一些相关数据，唯独没有对这个方剂的加减，没有这方面的记录。

舌质：红舌 3 例、淡舌 1 例，一共 4 例。

舌苔：白苔、腻苔、剥落苔。

脉象：沉脉、弦脉、弱脉、细脉、滑脉。

有麻黄升麻汤治愈机会的现代疾病并不多，包括慢性肾炎、慢性肝炎、慢性胃炎、慢性肠炎、慢性结肠炎、无菌性肠炎、植物神经功能紊乱、支气管扩张、支气管炎、肺脓疡、猩红热、更年期综合征，大致就这么多。

之前厥阴篇的条文等于把厥阴病和厥逆证都学完了。从本书的内容划分上看，接下来的内容还属于厥阴篇，但是从第 358 条一直往后的所有条文论述的分别是下利、呕和哕这一类的疾病。

大家都已经对《康平本》比较熟悉了，从第 358 条到第 381 条之间还有 23 条的内容，除了第 359 条的干姜黄芩黄连人参汤证之外，其余的条文不是降一字格排版就是降两字格排版的，这说明在原书（根据史料考证就是《汤液经》）中这一部分内容是没有的。再换一种说法，就是这些内容全是后人所加的，因为在《金匱要略》里对这一类的疾病也有专门的章节来论述，所以这也属于杂病一类。那为什么把这一部分单独附在厥阴篇的后边，恐怕现在还不能轻易下一个结论，因为没有相关的依据。

但有一点是非常清晰的，就是这 23 条所论述的内容都跟厥阴病无关。这里只有一条，因为古人在病理划分上不像现在弄得这么细，这个干姜黄芩黄连人参汤证从某种角度上说应该算阴证，放在厥阴

病里比较勉强，但是它有厥阴病的疾病基础，是一个寒热错杂的病。但是这里还有一个问题，这个条文以前是不是在这里？假如把所有降一字格和降两字格的条文全部剔除，那这个条文就不应该排在这了，应该排在厥阴篇非常靠前的位置。关于这点只是通过《康平本》才能得出的一个结论，在《宋本》里是不可能知道的。

伤寒四五日、腹中痛、若转气下、趣少腹者、此欲自利也、（358）

胡希恕：这条以下都论的下利。“腹中痛”，啊，他是…里有寒则腹中痛。尤其有寒，再有水，刺激这个肠粘膜他痛。“若转气下趋少腹”，如果，啊，不但疼，感觉这个转气向下，这是下利的征兆啊，是吧，所以说，“此欲自利也”。那么他为什么搁个“伤寒四五日”呢？你们想一想，啊，能想出来吗？太阳篇里头没有伤寒四五日，啊，传里而为下利，他是指着少阴病。所以他这个书啊，就是这样子，他这个日子不是随便搁的，他省话。这是少阴伤寒。二三日无里证，是吧？那阵儿得发汗。他这个书呢，得前后…啊，那么到四五天呢，他传里并发为太阴，就是要有这一种情况。这是说的这虚寒下利。所以他这腹中痛他就知道有寒了。这个少阴病跟那个太阳病一样，他有时候，啊，先传半表半里，再传里；也有的他越过半表半里，直接传里，啊。太阳病传里他传阳明的时候多，或者传半表半里呢，就是少阳。所以咱们头前儿你看一看那个，那日子都不是随便搁的。所以伤寒中风，啊，四五日的时候，五六日的时候，这都传少阳的时候。他过了这个期间呢，他就要传阳明。这是…这是太阳病。这个少阴病就不一样了。二三日的时候啊，他是纯粹在表。所以这个，啊，少阴病，啊，二三日可发汗，他用这个麻黄附子甘草汤，什么道理呢？他说，二三日无里证，故微发汗也。那么到四五日他就要传里了，啊。所以他这个书啊，你要整个一看呐，啊…你就明白了，少阴病的确不是像咱们

那个 说那个，啊，在里，不是的，根本它是在表。他传里嘛，他就有里证了，不传里他也没里证。可是他在表支持…维持在表的时间非常短暂，两三天。一到四五天就要传里了。那么这一段他就根据这一个来的。他这省话呀，啊，你一看伤寒四五日，啊，真要为这个阴寒下利，你就知道这是少阴病。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。

先做直译：患伤寒四五天的时间，如果表现为腹中痛同时患者感觉腹中似有气下行驱走于少腹的，此为欲发生下利的证候。

该条文论述的是太阳表证或者少阴表证，也就是表证这类疾病在经过四五天后没得到合理治疗，并且人体在与疾病抗争的过程中已经处于一种劣势的状态，病情有了进一步发展的这类情况。

从条文的述症看，这是疾病欲向着太阴病方向发展的情况。“腹中痛”在这应该是既有里寒证同时又有水饮证的一种反应。“转气下，趣少腹”可以理解成水走肠间、寒饮下行的一种证候。如果这类的情况再得不到合理的治疗，就容易发生下利这一类的证候。

此条大概就说了这么一个意思，这类的论述在降两字格条文中很多。实际上该条文论述的情况不是多么复杂的问题，假设“转气下、趣少腹”这一类的如果有肠鸣的话，那大概就是三个泻心汤中的某一个方证，而且像这种情况吃下去就好，这不是一个重症。

伤寒本自寒下、医复吐下之、寒格更逆吐下、若食入口即吐、干姜黄芩黄连人参汤主之、（359）

干姜 黄芩 黄连 人参各三两

右四味、以水六升、煮取二升、去滓、分温再服、

胡希恕：那么这一段呐，这注家都说是有错简。的确头一句话是不好解释。“伤寒本自寒下”，你由这一句话就可以解释了，“医

复吐下之”以后他有个“寒格”，“更逆吐下”，可见他以前就寒格，寒格呕吐啊。 什么叫做寒格呢？就是寒格于心下。就是胃，胃虚有寒。那么上边是热，你看他这个，这个后边这个方剂也知道了，就是胸中烦热，吐，啊。为什么吐呢？他这胃虚有水、寒，他是这么一个病。你要就这个“伤寒本自寒下”简直就不好讲，你要看到后边的寒格呢，这个“寒下”就指着“寒格”说的，本来他寒格，就是寒格于中，啊，热在上头，所以他…他要吐，啊。那么这个时候你再吐，这吐我们头前儿讲过，一吐这个内烦就发生，什么叫内烦？就使着胃，啊，就是胃…胃不和了。他本来就吐，有寒格，你再吃吐药，他更要吐了，是吧？所以这个吐药之后老是要愠愠欲吐。那么这个下呢，更不行了。这个下使着胃虚，这个寒更往上，是吧？所以这个“邪之所奏，其气必虚”嘛。胃虚了，那么底下这个寒呐，更往上攻。所这两个方面构成“食入口即吐”，那比一开始这寒格还凶了。用干姜黄芩黄连人参汤主之。那么这一节儿他都论下利呀，那么他这个没提下利，但是就这个方剂上看呢？肯定是下利。我们看看这个方剂，这个干姜、人参，啊，这是益中气了，啊，用干姜人参是补益中气的……（音频038完）

李冠杰：这条是顶格排版的条文，下边解读一下：

“伤寒，本自寒下”，仅从字面上解读这句话似乎文字有不完整之嫌，文字不太通顺。像这一类的在《伤寒论》里冠以“伤寒”的条文太多了，如果把“伤寒”两个字去掉，“本自寒下”至少在这本书里是唯一一处用这种方式来论述的。再者如果解释的话，它论述的方向倒是挺明确的，但是完全没有必要用这样的方式来论述，而且跟其他地方的论述从文风、语气上不是那么统一，所以此处有可能是有残简这类的情况，就是条文本身有残缺。但整体来理解条文的内容，它所论述的意思还是比较清晰的，不外乎两类情况：一类是在患伤寒的同时还伴有虚寒性的下利；另一类是在伤寒的同时还伴有下寒证或者

有里寒；但这两种情况没有质的区别，只是在症状上有没有下利的问题。另外有一点能够确定，此处论述的已经不是一个单纯的表证，而是表证与里虚寒证同病的一种病理状态。

接下来“医复吐下之”，这显然是误治。伤寒本身就不可下，再伴有里虚寒证的话，再施以下法就是错上加错！然而这种误治在太阳篇已经有多处这样的论述，但是这种情况在前边学习过程中经常强调一点，就是同样的情况，同样的误治方法造成的不良后果可能是不同的。从这个角度再来解读条文就比较容易理解了。实际上该条文论述的是表证同时又有里寒证，在这种情况下经过误治后出现了后边所说的“寒格”这类比较特殊的情况。此时既没有发生理中汤证，也没有发生四逆汤证，而是发生了寒热错杂的这类“寒格”的比较特殊的情况。

接下来“寒格更逆吐下”，指的就是上述这类情况经过吐下形成“寒格”后，表现出“吐下”的症状更为严重了。因为本条的方证是个典型的寒热错杂的证候，所以此处“寒格”还是不难理解的。“寒格”就是“里寒被格于下”的意思，其原因是由于有上热所致。

这一段文字粗看的话，论述的是形成“寒格”状态的原因，但真正论述的重点是“寒格”的特殊性。所谓“寒格”是一种寒热错杂而且具体表现为上热下寒的一种病理状态。根据条文论述从临床实践看，常常是因为在既有表证又伴有里虚寒证的情况下，误用了吐下这类的方法后，形成了这样一种特殊的局面。

但有个问题，经方理论是重病证不重病因，即使这类情况没有经过误治，甚至也没有表证的病理阶段，只要患者现这个方证，具备了这样的病理状态，就仍然是这个方剂的治疗范畴。从这个角度再来理解条文，其真实的含义就变得非常清晰了，实际上是在论述表证的同时伴有里寒证的情况下，误用吐下的方法不仅可以发生在这一条，之前特别是太阳篇里论述的各种各样的不良后果有时也会形成该条文

说的这种寒热错杂的特殊情况。

立体地看，这就是经方理论对于疾病发展变化的总结。我们整体解读这个条文，再把经方理论所有关于这类的论述整体解读，就会发现这确实是个非常特殊的情况。普遍的情况，或者误下后形成了半表半里证，或者形成了水证，或者形成了里寒证，或者表证仍没有解除，或甚至有的表证解除了还会自愈。但是这里上述情况都不是，这形成了“上热下寒”的特殊情况。再进一步，假如没有表证、没有经过表证的病理阶段，如果出现这种情况也要这样治。

下边论述的是该方证的典型症状反应。“若食入口即吐”，指的是吃东西以后随即就会吐出来的症状；或者饮食入口后马上就会出现呕吐的症状。这也是个比较特殊的情况，这是该方证最具特征性的一个症状反应。

从病理上看，主要是两方面的因素造成的：一方面，有严重的里虚寒证，本来就有里虚寒证再误用下法，就算是用温药下，里虚证也能加重；里虚寒证本来就挺重。另一方面，又有半表半里的虚热证，虽然在经方中具备这类病理特征的方证还有很多，最典型的是三个泻心汤，都是典型的半表半里有热、里有虚寒的方证，而且这类的方证当也常会出现呕吐或者下利的症状反应，但都与该方证这种吃了东西马上就要吐出来的“食入口即吐”的症状有明显的区别，都到不了这种程度。

在实际临床中该方证还有很多其他症状反应，临床资料显示干姜黄芩黄连人参汤证中，如下利、胸满、腹胀满、食欲不振、心烦等症状都有机会出现。但“食入口即吐”的症状在方证中出现的频率很高，同时这种症状反应既是最突出的，也是最具有特征性的一种，所以条文对其进行了比较详细的论述。其他的症状都隐含到方剂里了，一看方剂就明白，既有上热又有下寒，方剂既有黄芩又有黄连而且用量都不小。在这种病理下，比如出现“心烦”这类症状不是理所当然的吗？

所以很多其他症状就略而不论了。

该方证的病理比较简单：半表半里的虚热证合并里虚寒证。

下边作个小结：患伤寒后同时伴有虚寒性下利，而医者却又误施以吐下的方法治疗，因而造成“寒格”并出现较为严重的呕吐下利的情况。如果此时患者表现为“食入口即吐”的，为干姜黄芩黄连人参汤主治之证。

下边看看方子，这个方剂的组成比较好记，剂量都是一样的，干姜、黄芩、黄连、人参各三两。方剂中所有的药物都是现在已经比较熟悉的药，都是些常用药，在前边的学习中对这些药味都有所了解。药物之间的比例也没有明显的特别之处，比如小柴胡汤，柴胡八两其他的都在三两左右，但这个方剂里都是三两，重量是相等的。但是该方子的适应证却具有明显的特征性。在经方里有治疗呕吐功能的方剂方药很多，但像该方子能够治疗适合于寒热错杂的病理下出现的，特别是“食入口即吐”这种典型的反应情况的反而不多；另外还有一个跟这个差距挺大，就是大黄甘草汤，我们最后会讲一下。

这个方证的吐不仅仅是有“食入口即吐”的特点，而且从治疗意义上讲，如半夏、生姜这类典型止吐的药物治不了这个病，所以方剂里这种药一点也没有。说明这种呕吐是在寒热错杂的情况下发生的一种比较特殊的疾病。它表现也确实挺特殊的，吃了东西就吐，而且只有用这个方子才能取得比较理想的疗效，换一换其他的方药恐怕效果就会打折扣。

另外换一换角度看，从方剂的现代应用资料中还会发现，有应用该方剂机会的现代疾病大多数都是一些胃肠炎或者消化道之内的疾病，而且在现代医学诊断中也没有什么特殊的疾病，比如肿瘤或者恶性肿瘤、或者是一些不常规的病。但是学经方的都知道，像这一类的疾病放到现代医学来治，或者用中医其他的方法治疗，都很难取得经方这样的疗效。这说明实际上对这一类疾病性质的认识，还有待于进

一步研究。为什么在上热下寒的病理环境下，人体会出现吃了东西马上吐出来的情况？特别有点像现代医学常说的神经官能症这类的。但是这类情况在经方医学里早在两三千年以前，我们的祖先就通过临床实践找到了治疗这种特殊疾病的方法。其实这个疾病在临床中碰到的不是很多，但如果真碰到这种病人要是用不到这个方子，疗效肯定就差很多。比如用半夏泻心汤那一类的也不见得没有效果，但是跟这个比要差很远。

另外在《金匱要略》里有个大黄甘草汤，其方证的典型症状跟该方证的“食入口即吐”颇为相似，它是“食已即吐”，其实差不了多少，当然“食已即吐”似乎还没有“食入口即吐”发生的这么急迫。但这两个方证只是在这一个症状上有一个近似点，其他的在病理上相差很远，这个方证是寒热错杂，大黄甘草汤证是里实证，而且也没有此方证中的半表半里的虚热证，所以在临床中不难鉴别。

下边再看看该方证的临床统计资料（症状反应），出现最多的是呕吐，其次为大便溏泻、胸满、腹胀满、纳呆、心烦、呃逆、暖气、吞酸。

舌质：主要是淡舌，其次还有绛舌、尖边发红的舌、有齿痕的舌。

舌苔：黄苔、腻苔、白苔、滑苔。

脉象：弦脉、细脉、滑脉、虚脉、数脉、浮脉、沉脉、濡脉、洪脉，弦脉和细脉出现的频率比较高，浮脉、沉脉、洪脉、濡脉等出现的都非常少。

有应用该方剂治疗机会的现代疾病不是很多。大致找到的资料有：急性胃炎、慢性胃炎、神经性呃逆、食道炎、慢性结肠炎、慢性肝炎、慢性胆囊炎、消化道溃疡、急性肠炎、痢疾、霍乱、霍乱吐泻。

下边有一些不是正规西医的病名，但是临床应用中能帮助我们在理解这个方证上起到启示作用。比如夏日炎热时贪凉食而致吐泻交作这类的情况；以呕吐为主伴有心烦、口苦、苔黄、脉滑数这类的情况。

天热的时候人体往往容易发生一些热证，但又吃得特别凉，现实生活中这是常见的情况，特别是小孩子天热了以后吃雪糕、吃冰块什么的，吃一些在冰箱里经过冷冻的食物，就容易出现一些比较特殊的疾病。当然吃了以后不一定就发生这个方证，但如果出现了这类的情况，大家可以在临床中去关注一下是不是有寒热错杂的情况。

另外还有一些像幼儿便溏、吐乳、同时又伴有口舌糜烂这类的情况，小孩子在临床中也是很常见的，而且这是很令家长头疼的事。小孩子口舌糜烂就不怎么吃东西，一吃东西就疼，还便溏、吐乳。这时既有上热又有下寒，另外在临床中还有一个很重要的诊断证据——看有没有肠鸣；如果有肠鸣，十有八九是甘草泻心汤证；没有肠鸣，就可以斟酌一下看有没有应用这个方子的机会。

我现在在临床中百分之百用经方治病，慢慢就有一种体悟，越是这些平时不怎么常用的、比较偏的方子，要是真碰到这样的病人，离了这个方子治不了。比如真正的奔豚证，不是苓桂枣甘汤、桂枝加桂汤那类的，就是奔豚汤治的那种要是临床中碰到了真是疑难病，但要真正用奔豚汤治就跟普通病一样。有一个报道，患者因为这个病几乎快要倾家荡产了，到处都看过就治不了。最后山东省中医院的一个老大夫说医书上有这种病，奔豚病，就按这个药吃，过了几个月报道说治愈了。假如想不到这个方子，怎么去治？

有一些比较偏的方子在临床中真是这样，曾经有一个病人，喘、胸部气短、感觉特别地闷，他不是这么单纯的一个方证，我给他治，在别的方剂的基础上加了茯苓杏仁甘草汤后疗效明显提高了。这就说明这个方子虽然三味药也没有什么特殊的，但是它治的这个情况其他的方剂治不了。

下面把我看的医案跟大家说一说，能加深对这个方证的理解。有个病人注射百日咳疫苗后（这肯定是个小孩子），当天晚上发热恶寒，还有个症状就是食入口即吐，吃了东西马上就吐；胸痛（这个我觉得

不好理解，这肯定不是一个小孩子，那这个胸痛医生是怎么知道的？或许他有一些特殊的证候）；大便三天没解，神志昏沉，他自己恐怕有些东西也没法很明显的表现出来。测量体温是 38 度，舌红苔黄脉沉细。然后用干姜黄芩黄连人参汤一剂奏效，症状就消失了，另外用了一剂小柴胡汤善后。大家看，这也是一个用经方经验比较老道的医生的医案。

下利有微热而渴、脉弱者、令自愈^①、（360）

注：“令自愈”《宋本》作“今自愈”。

胡希恕：（音频缺如）

下利不渴者，为里有寒，今下利而渴，则为里有热甚明，但身只有微热，而脉又弱，是邪已衰，而热渐退为候，故断言曰：今之下利必自愈。此述热利欲自愈的脉和证。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。条文中的“令自愈”在《宋本》里是“今自愈”，本来这两个字应该是差距不小，但唯独放在这里对条文的本意影响还真不大。一般地说，“令自愈”比较准确一些。下面解读：

直译：下利同时又表现为微热而渴并且脉弱的，这类情况可以自愈。

该条文论述的实际是现代疾病中轻微的胃肠炎之类的疾病。第 277 条是“自利不渴属太阴，其脏有寒故也，当温之”，再看看该条文，这里“微热消渴”说明此时的“下利”应该是热性的。因为第 277 条寒性的“下利”是“自利不渴”，一般都不会表现为渴，特别不是重症的时候。

像这种轻微的热性下利，脉象又表现为弱脉，说明此时的病情就比较缓了，没有急迫的病势，所以这是一种疾病向愈的征候。因此条文就说让其自己好就行了，不用管它，言外之意就是不要治了。

下利脉数、有微热汗出、令自愈^①、设复紧为未解、（361）

注：“令自愈”《宋本》作“今自愈”。

胡希恕：（音频缺如）

下利脉数为有热，但只微热而有汗出，则热共汗而外越，故知此利当自愈；假设脉数而复紧，为热犹实，可肯定为未欲解。由脉复紧为未解观之，则前之脉数当亦必复缓弱，此承上条说明热利欲愈或否的脉证。

李冠杰：这也是降两字格排版的条文，“令自愈”在《宋本》里也是“今自愈”。

直译：下利并且表现为脉数而且有微热汗出的，可以自愈；如果出现脉紧的，则说明疾病尚未解除。

“下利脉数”，这里也是一种热性下利。“微热汗出”中的“微热”说明病情不是特别重，只是微热而已；“汗出”，此处既然是个因热证造成的疾病，但同时患者又有汗出，说明这个热可以外越，里热可以随着汗液散发一些，实际上人体这些反应都是正常的。这基本处于一个正常的状态，所以这种热证可以得去，这是一种可以自愈的证候。假如脉此时表现为“紧脉”，这个紧脉是在“下利脉数”的同时脉现紧象，就说明不仅有里热，同时病势还比较重，病情还处在一个比较急迫的发展趋势。因此条文就说“为未解”，实际就是病势没那么缓和。

下利、手足厥冷、无脉者、灸之不温^①、若脉不还、反微喘者死、小阴负趺阳者^②、为顺也、（362）

注：

1. “灸之不温”《宋本》作“灸之不温”。
2. “小阴负趺阳者”《宋本》作“少阴负趺阳者”。

胡希恕：（音频缺如）

下利，手足厥冷以至无脉，为阴寒极虚欲脱之候，宜急灸之。若仍手足不温，而脉不还，反微喘者，此为生机欲息，气脱于上也，故死。此述阴寒下利的死证。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。条文里的“灸之不温”在《宋本》里是“灸之不温”，《宋本》是对的，恐怕这是笔误。“小阴负趺阳者”在《宋本》里是“少阴负趺阳者”，《宋本》也是对的。一般来讲，此处不能轻易把它理解成笔误，因为“小”和“少”差的一笔太大，那为什么会抄成了“小”？不好说。但是这个字非常明显，说“小阴”说不通，“少阴”跟后边“负趺阳”能够顺理成章。

直译：下利同时又表现为手足逆冷而且无脉的，用灸法治疗之后仍四肢不温，同时脉也没有出现，患者反而出现了微喘的为死证；如果少阴脉较趺阳脉为弱的，说明病情为顺候。

该条文应分成两段解读，第一段就是前半部分所谓的死证。从述症看，实际上是一种里虚寒证较为严重的下利，应该不是多么特殊的疾病，本来应属于通脉四逆汤或者四逆汤这类方剂的治疗范畴，甚至再严重一点，也无非是通脉四逆加猪胆汁汤这类的方剂，但是该作者却用了灸法治疗，这就相差太远了。这一类的方证如果用经方不是多么难治的病，但要用灸法恐怕不会取得满意的疗效。所以这里致使病情不减反而加重，以至最后酿成了严重的医疗事故，把人给治死了！通过这段论述可以明显看出该作者对经方理论的理解存在着严重的偏差，学习经方辩证体系的很多人一看大概都能知道这是个什么样的方证，但他偏偏用灸法治疗，人死了怨谁？

第二段“少阴负趺阳者，为顺也”，“少阴”指的是少阴脉，其位于脚踝内侧，在后侧部的大凹陷处的边缘有个浅表性的动脉，这就是少阴脉。“趺阳”指的是趺阳脉，也在脚踝前侧。“负”是“不及”

的意思。在《内经》理论中，少阴脉候肾气，趺阳脉候胃气。这段文字简单理解，论述的就是此时的患者如果胃功能强于肾功能，则疾病就处于一种缓解的病势。但该条文的作者还另有深意，因为他始终是以《内经》理论来解读经方理论，所以这里的少阴、趺阳还含有五行生克的意思。这样分析的原因是其他很多研究《伤寒》的人也都是这么解释的，这种解释不对，我们得知道不对在哪儿，这也不是硬给该作者扣上一个大帽子，看看《金匱要略》的第一篇“脏腑经络先后病脉证第一”的内容就清楚了，可以看出他在这方面有一套完整的理论体系。胡老就因为不想讲这套东西，曾经出现把学生给讲罢课的情况，可见理论分歧还是根深蒂固。在五行理论中少阴主肾气属水，趺阳主胃气属土，出现下利时如果趺阳脉强于少阴脉，说明土比水强，土能克水，这就是正常现象，就为顺象，疾病的趋势就比较缓。假如反过来，少阴脉强于趺阳脉，则说明土比水弱，土不能克水而被水所侮，这就是不正常的现象，就为逆象，疾病就不容易痊愈。

这些东西不仅和经方理论不合拍，也得不到临床实践的支持，无法与临床实践接轨。这些内容加入经方理论已经近二千年了，对正确理解经方理论造成了严重的误导。当把《康平本》客观、深入地和《宋本》进行对比后，有个有意思的现象：降两字格排版的条文有人口口声声称之为仲景如何如何教导我们，仲景怎么怎么说的，实际再想想，这事不能怨他们，这是历史上这本书的特殊严酷的环境造成的局面。实际上我们这次就是“正本清源学经方”，通过这种方式真正正本清源、最大限度看到了《伤寒论》真实面貌后，再反过来看看那些整天把这类条文挂在嘴边的人不就是自欺欺人吗？但客观的讲，他们也不知道谁欺骗他们，事实上不都是这些东西误导了吗？

不用提到多高的理论高度去理解这个问题，就从最朴实的地方看，现在我们知道《宋本》实际上至少是四本书，顶格排版的内容是一本，降一字格排版的是一本，降二字格排版的是一本，其他的注解

内容（嵌注、旁注、附注）因为不知道作者是谁，也可以另外算作一本。为什么要这么分？因为不是一个人写的。从这个角度再看，假设把《毛泽东选集》和《邓小平选集》当作同一个人写的同一本书来解读，那不成笑话了吗？这里也是性质相同的问题。

下利寸脉反浮数、尺中自涩者、必清脓血、（363）

胡希恕：（音频缺如）

下利为病在里，脉当沉，今脉反浮数，乃热邪亢盛之象。涩主亡血，尺中自涩，为血亡失于下，下利见此脉，故知必便脓血。此述热利便脓血的脉应。

李冠杰：这条在《康平本》里是降二字格排版的条文。

直译：下利反而现寸脉浮而且数，尺中脉涩的，可能会出现便脓血的情况。

解读一下，条文的本意是要用脉象来说明一种病理状态。“下利”多为里证，应之于脉常现沉脉，而此时患者反而现浮而数的脉，不仅说明这个下利是热利，同时还说明病势比较重。另外还有尺脉现涩象，说明有亡血于里的证候，所以多会出现便脓血（脓血便）的情况。但大量的临床数据表明这类的情况，热利而且同时又有脓血便的，并不一定都会现上述这种脉象；另外即使有这种脉象，也不一定会出现脓血便。所以这种以脉定证的理论观点跟经方是不通的，这里没必要过细地去推敲，且不说有多大成分能得到临床实践验证，这种以脉定证的观点本身就不对。

下利脉沉弦者、下重也、脉大者、为未止、脉微弱数者、为欲自止、虽发热不死、（365）

胡希恕：（音频缺如）

下利，脉沉弦为里急后重之应，脉大为邪热盛，故为未止，脉微

弱为邪已衰，虽脉还数而热未已，则已可断言为欲自止，即暂发热，不久当已，必不至于死也。此述里急后重的热利，即今所谓痢疾，而示其欲自止或否的脉应。由脉微弱数则不死观之，脉大实数则必死无疑。

李冠杰：这条也是降两字格排版的条文。按照《康平本》的顺序这条在第 363 条之后，在《宋本》里是第 365 条，顺序上做了调整，但仔细看也没什么特别的深意。我们就按着《康平本》的顺序和《宋本》的条文号码来学习。

直译：下利如果出现脉沉弦的，多会有下重的症状；如果脉大的，则说明病情较重；如果脉微弱数的，则为下利自止的征候。虽然发热，不为死证。

条文论述的是下利的发展变化应之于脉的一些反应。虽然在临床中并不是所有患者的脉都会按这一条规律表现出来，但有一个“脉大”值得注意，在这种状态下出现大脉，说明人体在抗御疾病的过程中因病情比较重，所以表现为一种不正常的亢奋状态，说明疾病正处于发展期（现代医学喜欢用这种说法）；而“脉微弱数”，则说明疾病进入了衰减期，是一种比较缓和的病势，一个向愈的征候。但是“脉沉弦者下重也”，也犯了以脉定证、机械的和绝对化的倾向。假如患者现沉弦的脉，但又没有下重的感觉，这类情况又作何解释？这解释不了的，像这种情况也是完全有可能的。

下利清谷、不可攻表、汗出必胀满、（364）下利脉沉而迟、其人面少赤、身有微热、下利清谷者、必郁冒汗出而解、（366）

病人必微厥、所以然者、其面载阳^①、下虚故也、（366）

注：“其面载阳”《宋本》作“其面戴阳”。

胡希恕：（音频缺如）

364 条：下利清谷，为里虚寒，即使有表证，也应先救其里，而不可攻表，若误攻其表，汗出则益虚其里，必胀满不能食。

366 条：下利脉沉而迟，为阴寒在里，但其人面少赤，身有微热，已有阴去阳复形象，故虽下利清谷，则必郁冒汗出而解，病人亦必微厥，所以然者，以其人面戴阳，而下虚，其欲自解，则必作战汗等瞑眩反应。此论阴寒下利，阴退阳复必自愈。由于身微热其面戴阳，则知必解，但其下虚，欲自解者，必发瞑眩，郁冒汗出而微厥，即瞑眩状。

李冠杰：这两条比较乱。“下利清谷，不可攻表，汗出必胀满”是第 364 条。接下来是第 366 条降两字格排版部份：“下利，脉沉而迟，其人面少赤，身有微热，下利清谷者，必郁冒汗出而解”。再来是降一字格排版部分：“病人必微厥，所以然者，其面载阳，下虚故也”。

下面把这几条展开，一点一点理顺一下。这几条在《康平本》里既有降两字格排版的内容，也有降一字格排版内容，分了两个自然段，降两字格排版的内容自成一个段落，降一字格排版的又单独是一段。

我们分成三部分学习：第一部分从“下利清谷”到“汗出必胀满”，在《宋本》里是第 364 条；第二部分从“下利脉沉而迟”到“必郁冒汗出而解”，在《宋本》里是第 366 条。第 366 条中的降两字格排版内容在《康平本》里和第 364 条是同一个段落，虽然这里没有多少深意，但毕竟有差别，就跟大家交代清楚。第三部分就是降一字格排版的文字。下面解读：

“下利清谷”，说明有严重的里虚寒证，按经方治疗原则此时即使有表证，也应先温里后解表，或解表温里同时进行，单纯解表就属于误治。另外从条文看，此处没有表证的述症，现在就假设有表证的情况，因此条文里也说得很明确，此时“不可攻表”。

那一旦误治会怎样？发汗后，就容易出现“腹胀满”这类的情况，

实际上这是里虚寒证加重的一种反应。该条文只是在此处论述了一个具体的述症，就是“汗出必胀满”，在以前的条文中这类情况有过其他的论述，这里只是换了一种说法。

第二部分“下利，脉沉而迟，其人面少赤，身有微热，下利清谷者，必郁冒汗出而解”。该条文从《康平本》看能说明一点问题，实际上是该条文作者根据第二段降一字格条文的内容，按照自己的理解和经验所作的补充。因为降一字格的条文是残缺的，残缺的内容想表达的意思该条文的作者也拿不准，所以他就根据降一字格条文的论述又加了自己的一套经验。那么本条实际论述的是一种既有表证同时又有里虚寒证的情况；“下利脉沉而迟”和“下利清谷”，这是典型的里虚寒证的证候；“其人面少赤，身有微热”，这是所谓的阳气浮于表的反应；但从最后“郁冒汗出而解”的结果看，这里应该有表证的因素存在。值得我们注意的就是这类情况，既然经过瞑眩反应后可以自愈（“郁冒汗出而解”），那必然是一个表里同病的轻证，绝对不会是个很重的病。假如是很重的病，不会以这种方式来自解。

第三部分“病人必微厥，所以然者，其面戴阳，下虚故也”。“其面戴阳”在《宋本》里是“其面戴阳”，这应该是对的。“戴阳”在中医里说不太通，很少有人这么说。这段从《康平本》能明显看出问题，它跟前边的第 366 条第一部分不是一段，排版方式也不同。不仅如此，再回过头来看《宋本》也会发现，这段条文和第 366 条第一部分在文意上有明显不衔接的意味，不是很通顺。所以《康平本》这里反映的是一个真实面貌。实际上这段是个残缺的条文，是一个完整条文的后半部分，或者是中间部分，也许其后还有内容。但是前面有什么，后面有什么，已经都不知道了。此外该条中有“其面戴阳”的论述，所以降两字格条文的作者又根据这个症状写了与之相关的 366 条第一部分的内容。这说明降两字格的作者当时见到降一字格的条文已经是残缺的，他也无法确定前面到底是什么，所以干脆自己又写了一条，

这样的解释是非常合理的。

因为这段条文残缺的都是主要的内容，比如一些述症之类的，所以这类条文就不易强解，搁置起来就行了。像这种情况如果见不到《康平本》，没有任何人会这样解读，但这却是这本书的本来面目。

下利脉数而渴者、令自愈^①、设不差、必清脓血、以有热故也、（367）

注：“令自愈”《宋本》作“今自愈”。

胡希恕：（音频 039 始）……由于这个人呐，不注意寻常饮食，啊！不知摄生，乱吃乱喝，肠胃里头有热，哎，到时候他泻肚。所以泻肚有时候是好病啊，啊，他这…腐秽当去嘛。咱头前儿也讲了，在阳明篇里头，啊，在这个少阴篇里头，都…都讲了，腐秽当去，拉一顿稀屎，热也没了。可是也有拉了稀屎，这热太厉害，拉稀屎也没好，后来变痢疾了。这一个在临床这个病很多，啊。所以这个书啊，没有临床经验的人他不好讲。你像这一…这一段讲“下利脉数而渴者，令自愈”，这你照字面没法讲的，啊。他有…他…通过临床他认识到这个病，很好讲。所以你们看看那个注家的这个解释，在自己瞎想的，啊。所以陈修园说过，他说这个仲景这个书啊，越读，啊，越有味…越有味道，是这样子。他这个方剂呀，是越用越有验，真是这样子。我是的确有这个体会。所以他这个书啊，好好看，真比看这个…啊，比到戏园子还好。他里头相当的细腻，他说得非常的有意思。你要从字面看呐，看不出什么。你像我们头前儿所说那个，啊，伤寒四五日，腹中痛，啊，若转气下趋少腹者，欲下利也。你像那一个“伤寒四五日”他不是随便搁的。他这个书啊，细腻得很。也有错的，你看，刚才说那个，啊…“伤寒本自寒下”那恐怕有错误。但是讲能讲的，啊。他那个“寒格，更逆吐下”可见这寒格就是说的这个“本自寒下”。

这古人，反正这里头有错字。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文，条文中的“令自愈”在《宋本》里也是“今自愈”。

直译：下利出现脉数而渴的，一般可自愈；如果未能自愈的，则可能出现便脓血的情况，这是由于里有热的缘故。

“下利脉数而渴者”，明显是指在里热证的病理状态下发生了下利的症状。“令自愈”则说明此处是一种比较轻的下利，不是下利的重症。但是后面“设不差，必清脓血”论述的是疾病出现的另一种发展方向。这类情况有两种可能：一种是自愈；另一种是没自愈。没自愈常常会发展为由病情较轻变为病情较重，下利的同时会出现便脓血的情况。后面还做了病理解释：这是由于热证造成的下利，容易出现这种情况。

该条文实际论述的就是临床中下利所出现的两种不同发展方向，这也是一种常识。另外“必清脓血”只能理解成有可能出现脓血，不是所有热利都会出现这种情况。

下利后脉绝、手足厥冷、晬时脉还、手足温者生、脉不还者死、（368）

胡希恕：这一个也是，啊，虚寒下利的死证。“下利后”，啊，这是，“下利后者”下利已止了，下利已止之后了。那么这个时候，是胃沉衰而津液枯竭了。不但“手足厥冷”，这是，啊，说明胃气已衰。而且“脉绝”，脉绝心脏也衰了。“晬时者”，12个时辰，现在说就24小时了，就是昼夜一周。要如果在这个周时，啊，脉逐渐还，手足温，就是胃气恢复，津液自生，血液也自生了，啊，心也不怎么衰竭了，这是准好的。所以他这个“下利止”，有两种问题。一种他是好现象，好现象，可当时一“止”由于这个“下”亡失津液太甚了，啊，胃也太虚了，所以他有脉绝，手足厥冷，啊，这么一种

情况发生。那么这个时候再逐渐恢复呢，啊，这个胃气逐渐恢复了，血液…啊，这个胃又能布谷气，这个血液也逐渐恢复，心脏衰竭也恢复，这是个好现象，这个病是要自愈的；也有“下利止”了，他是无可下而“下利止”，所谓精气怠尽，啊。这个下利，阴寒下利有这么两种情形。“下利止”不一定是好现象，啊。那么这一阵儿你看情形了，如果“脉绝，手足厥冷”，啊，这个你要观察。如果“晬时脉还，手足温”这是没问题；如果脉不还，这是胃气已败，心气衰竭，那非死不可。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。

直译：下利后患者出现无脉，同时手足厥冷，如果十二个小时之内脉逐渐恢复、手足也变温的，是疾病向愈的一种情况；如果脉仍不恢复的，则为死证。

该条文论述的是一种严重的里虚寒性下利。此外还论述了利止后可能出现的两种情况。

“下利后脉绝，手足厥冷，”此处下利后指的是下利止后，但这并不是一种自愈的机制，而是下利太严重了、消化道内已经无物可下的机制，就是没有东西可解了。之前由于过度的下利，必然会造成人体体液虚竭，并且人体的整体机能也陷入了比较严重的沉衰状态，再加上胃气已经趋于衰败，所以应之于脉，脉已经沉弱到摸不到的程度；同时应之于体表，也表现为四肢逆冷。

“晬时脉不还，手足温者，生”，这是古人通过临床实践总结出的经验，上述情况假如人体能恢复，则常会在半天（现在的12个小时）以内脉慢慢出现，手足也渐渐没有那么厥冷，也开始变温了。这说明人体有自我恢复的证候，人体已经开始自我恢复了。但假如过了半天后还不见脉出，说明此时人体与疾病的抗争处于劣势，本来病就重这就是一种危象，所以说“脉不还者，死”。虽然现在临床中真正身边守着这样一个病人的机会比较少，但这种疾病发展变化的规律对

我们来说非常有用，因为这确实是自然的、客观的、来自临床的。毕竟是在什么样的情况下出现什么样的证候，有什么样的趋势，这里讲的还是比较好的。当然关于治疗方面就是另一层意思了。

虽然该条文是通过临床实践总结出的一个规律性的东西，在临床中有很高的价值，但也要客观地看到另一方面，就是其论述完全忽视了临床治疗这个重要的医学因素。医生是治病的，不能守着病人等死，单纯看其论述，此时医者好像只有等闲视之的份儿了，完全无能为力了。其实仔细分析该条文的述症，这里就是通脉四逆汤或者通脉四逆加猪胆汁汤这类的方证，就算再严重点，也应该按照这个方向给予治疗。如果面对病这么重的患者任由疾病自然发展，这是不对的。当然也应该正视一个现实，不是所有的病人都能通过合理的治疗来治好，医学也不是万能的，但对于医生来说服药以后不效和任由患者的疾病自然发展，这是两种不同性质的问题。我们再拓宽一下视野，那些顶格排版的条文，甚至包括某些降一字格排版的条文，没有一条是论述这类情况的，就是不去治，然后看着人死了，没有这样讲的。当然这也不是该作者想要的结果，在这中间也未必没有治疗，但至少是没有治到点子上。另外从其他条文也能看出，该作者在某些情况下不会治这种病，不会用经方。

伤寒、下利日十余行、脉反实者死、（369）

胡希恕：这一个是“热利”，啊。伤寒发热嘛，下利发热，而下的次数频繁，啊，一天十数…十数……十数次。那么这么样子下，这个下利是虚人的一个病啊，咱们寻常有这么一句话，说“好汉子架不住三泡屎”啊，这一天拉十几次，这个脉应该虚，是吧？脉不虚反实，这个反实不是人身体结实，这是说这个“病实”，邪气实，这一个非死不可。所以这个，这个头前有了，啊，这一段跟这个…嗯，头前儿这个下利，有微热而渴，脉弱者，那是自愈。这一个…要是热利，泻

的次数既多，而脉反实者，这一个不可轻视，大概都是一个坏现象。人再发热，啊，下利无度，而脉再实，这一个要加小心。这一个都指着下痢呀，都指着痢疾那个痢，不是指一般的水泄。这一个就不要轻视。干紧呐，啊，留住院吧，啊，到急诊室观察也好啊。所以这一个应该知道，啊。这以后这个下…这个下利呢，在临床不能少遇着。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。

直译：伤寒同时又一天下利十余次，如果脉反实的为死证。

学习该条文应重点理解两层意思：第一，下利日十余行必然会造成人虚，这种下利比较重，人肯定陷于一种虚象了，但此时脉反而出现实象，说明病情非常严重。也就是脉和人体的反应是两个方向的问题，人体趋于虚，脉反倒趋于实，表明这之间有矛盾，必有其他原因在里面。第二，该条文实际论述的是一种人虚病实的情况。这时，常会出现一种两难的局面：假如要补，病情不允许，因为有实证；假如要攻，人又虚，又不易用攻法，这是在临床中比较棘手的问题，所以此处称之为死证。

下利清谷、里寒外热、汗出而厥者、通脉回逆汤^①主之、

②（370）

注：

1. “通脉回逆汤”《宋本》作“通脉四逆汤”。
2. 《宋本》此处有通脉四逆汤方及方后注，此从略。

胡希恕：这个“汗出而厥”呀，到这一个地方用四逆汤就行，他搁个通脉四逆汤恐怕底下还应该有个“脉微欲绝”四个字。他所以那个…为什么呢？因为通脉四逆汤头前儿讲过，通脉嘛，脉没有了，脉绝，或者脉微欲绝，这是个虚脱的样子，所以他搁个通脉四逆汤。“下利清谷，里寒外热”，啊，里是真寒呐，外就是我才刚才说那个无根之火了，外边儿，比方身有微热了，或者是面色赤，这都不是好现象。

他这个与这个 366，啊，所以不同，你们好好看一看，那一个是下利脉沉而迟，他不是厥。这个四肢厥冷啊，说明这个胃…胃气虚，谷气不达于四末，是吧？那么那个“下利清谷”，啊，那一个也是“下利清谷”啊！那一个其人面色赤身有微热，不也是有外热吗？可是他里寒没有这一个凶。这一个它是胃有虚竭的一个反应了。所以这一个，这个外热不是好现象，不是要出汗，啊，而解除他这个疾病。而且他已经汗出，他病还那样子，这个汗出是脱汗。就是虚脱那个脱了，啊。那么他没说“脉微欲绝”，肯定有的，要不然他不会用通脉四逆汤的。通脉四逆汤就四逆汤，啊，他把附子啊，干姜都加量了，附子他搁大者一枚，是吧？那么干姜呢？啊，强人可四两，这都要加重，所以干姜附子。咱们讲那个白通汤的时候我给讲了，所以白通汤肯定它治不了复脉，啊。因为他那附子干姜用的量也小，而且他这个葱白呀，是发汗，起发汗作用的。真正里虚寒到这么一个程度，啊，心力也衰竭了，那你还给发汗，没有道理。所以那一个我说，就是应该通脉四逆加猪胆汁，啊，根据全书上看的。那么这一个呢？寒是真寒。这个热，这是寒盛得极了，身上那点残阳啊，都跑到外头来了，这是个最坏的现象，啊。脉微再欲绝，那你得赶紧用通脉四逆汤以复其脉。这讲治疗了，头前儿我们讲到，这个 370 条儿以前，全是为下利总括的论述，生死进退，啊，全是。与厥一样。咱们头前儿讲那个厥，他也是反复论这个厥，啊，有生有死。那么后来他讲治疗了。那么对下利也如此的。那么这一个，他说是下利清谷，啊，里寒外热，汗出而厥者，要用通脉四逆汤。这里头隐含着有“脉微欲绝”啊！他没说呀，因为这一个方子，头前儿说多少次了。所以我们研究他这东西呀，就把这个，这个方剂各条儿的这个论述呢，搁到集中看就好了。这个通脉四逆汤，就是四逆汤，把附子、干姜增其用量。这个附子这个药啊，附子干姜这两个药啊，这就是人的这个，这个生理机能啊，极度沉衰了，连心…心也衰了嘛。非这个附子大力，他不能恢复的。这个时候用的阴寒的

药物一点儿也用不得，连人参都用不得，人参它微寒呐，啊。那么只有四逆汤这一类的药，才能够亢进他这个机能。所以这一个，咱们说这四逆汤也好啊，通脉四逆汤也好，都有强心作用。这一个强心作用在什么时候？都是要虚脱这个时候。你看他这个书，你前后看吧，没有到这个时候用人参的。所以咱们拿人参汤治这个病，一治一个死。所以咱们通过临床啊，应该，啊，否定的就把他否定了，肯定起来就把他肯定了。所以咱们这些年临床，啊，遇着了，这一个用独参汤，下回还用独参汤，那一个死了，这个也跟着走。他也…嘿…他也…嘿…也，他不觉悟。真是这样子，这我见着就多了。

李冠杰：这条在《康平本》里是降一字格排版的条文。条文的“通脉回逆汤”在《宋本》里是“通脉四逆汤”，另外在条文最后还附有通脉四逆汤方和方后注解，《康平本》里没有。下边解读：

“下利清谷”，这是比较严重的里虚寒证的下利。

“里寒外热”，这是两种不同性质的问题，不要认为这都是解释病理的，一个是病理，一个是症状。“里寒”是指病理而言，阐明下利清谷的病理就是里虚寒证。“外热”指的是患者在下利清谷的同时还有发热的症状，实际上这里的发热就是体温升高。在临床中这也是一种常见症状，有很多在中医看来属于里虚寒证的胃肠炎症一类疾病的患者，也常表现有体温升高的症状。但此时的体温偏高不等于存在着外热的病理因素，从该条文所用的治疗方剂看就是最好的说明。这时的体温升高，只是人体在抗御疾病过程中表现出来的一种症状而已，这种所谓的外热（体温升高）只是一种表象，并不能反映疾病的本质。假设反映的是疾病的本质，那用通脉四逆汤至少还得加其他去热的药。

刚才讲过，如果治疗上述这类疾病，真正有热象就应该用去热的药，但这只是一个理论上的说法。因为经方中的一个治疗原则是有里虚寒的要先温里后解表，但此处除了体温高之外，没有其他表证的症

状，把里虚寒性的下利用通脉四逆汤治好了，体温就下来了。所以这个体温高，实际是一种里虚寒证的特殊反应而不是表证，因此这种热反映的不是疾病的本质。在这个问题上讲这么多，原因是这种观点在中医历史上还没有，凡遇到这类问题我就想跟大家说清楚，这是事物的本来面目。在临床中凡遇到这类问题必须得这么想，假如不这样最终影响的就是治疗效果。

“汗出而厥”，这里“汗出”指的是在阴性里虚寒证的情况下表现出来的“脱汗”，是一种很危重的状态。“厥”指的是人体陷于一种机能沉衰的阴性里虚寒证的反应。

该条文实际是作者对通脉四逆汤证所做的补充。在第 317 条通脉四逆汤证顶格排版的条文中就有“下利清谷、里寒外热”的论述，该条又补充了一个“汗出而厥”。在此又说明了另一层意思，就是在“下利清谷、里寒外热”的情况下，同时又表现为“汗出而厥”的，也是通脉四逆汤的治疗范畴。这种条文必是该作者的临床经验所得，所以条文的价值很高。

热利下重者、白头翁汤主之、（371）

白头翁二两 黄蘗三两 黄连三两 秦皮三两

右四味、以水七升、煮取二升、去滓、温服一升、不愈、更服一升、

胡希恕：这个“通脉四逆汤”治阴寒下利最重的。那么这“热利”呢？他一个个也…也在底下，啊，讲了。他说“热利下重者”，下重就是里急后重了，啊！蹲肚，白头翁汤主之。这几个药相当的好。这个白头翁这个药啊，这几个药都是苦寒，都起收敛作用，唯有白头翁，你看那个《本草》上就有，它能够又能够治痛，又能够逐血。逐血就是，啊，它有些祛瘀作用。所以脓血便用它那相当好，啊。而且这几

个药啊，都…他这个收敛作用是苦寒呐，有消炎，啊，止…止利的，止利、止血的作用。那么虽然这么说，但是我们要遇着这个病啊，比方说遇着这个热利下重，只是用这四个药…我记得我给…寻常那一回作报告我还说过呢，白头翁汤可用，要加大黄，啊。这个你们在临床上遇着，你们随便加，没有错误的。不用加太多，就搁6克就行，啊，那么这个书上就是二两了。这个白头翁二两错的，啊。这个白头翁他也有个注，应该三两。这几个，这几个药是等分，全是三两。他这白头翁搁这二两在这个，在《玉函》它就是三两。这一个份量是错的。他是以白头翁为主啊。啊，他这个药，也是三两。那么这个热利，头前儿都讲喽，在他这脉，啊，脉数、下利，啊，身有热，或者渴而下利，脉数，这都是热利呀，啊，这头前儿讲了。那么这一种热利，以至于下重，这就正说明这个痢疾，那么可以用白头翁。要如果血便这一类的，下血。这个赤痢呀，这个我在临床上遇着过，他，他那拉下那个东西呀，就血汤子，没有粪便。这种痢疾厉害，说死就死，啊。这一个你要用白头翁汤啊，加阿胶。他这个有，在这妇科上有，他说这妇人在妊娠的时候，下利虚极，白头翁加甘草阿胶汤主之。这个阿胶啊，啊，对于这个…这个…这个…赤痢，啊，非常好，同时再加点儿甘草。学生：胡老师，你说这样情况加大黄行不行？加……胡老：啊？那该下，他里急后重就得加大黄。学生：就是这下血？胡老：那没有，没有问题的。这个，我遇着这么一个老太太，生生让人给药死了。她就是开始就得呀，就是赤痢这一类的东西。一他不是真正西医，他就是卖药的，以前做过药房反正，他就让人吃什么？吃这个硫酸镁。他说你吃，泄出大便来就好了，哈，哈，哈！她那净下血，她那儿泻大便去呀！她那儿子挺好，后来，泄了七天，那人还不完蛋嘛！找我去，我一摸脉，这个人脑袋就，就耷拉下来了，我让她儿子，你赶紧送隔壁医院去吧，到不了医院就死了。他这…这一个…这个硫酸镁那一味药，单独那么打，那哪儿行啊？尤其这一种赤痢，真是血，净

血、纯血。就像那个，啊…粟米汤子那个东西。这个痢疾是最厉害。但是用白头翁啊，加甘草阿胶，他这个里急后重的时候少。他这种泻利无度。要没有里急后重就加甘草、阿胶。这个方子最常用了，一般的痢疾没有里急后重，我们用白头翁汤就行；有里急后重可以加大黄。他现的柴胡证呢？那你搁大柴胡加石膏那一类的办法。所以，主要的张仲景这一部书啊，注重到最后是方证，就是方剂的适应症，你非到这个地方不可。所以一般研究这个仲景这书的人，是认为经方不好使。不是告诉你那一个方子治什么病，他让你辨证啊！他这个方子都有一定的适应的一个证候。你像我们头前儿讲那个太阳病，是吧？发热，汗出，恶风，脉缓，它桂枝汤主之。你用旁的就不行。他非常严，他规矩严谨。他怎么的？他辨到这个最后啊，非常尖端。咱们寻常，咱们现在辨证，这个虚了，那个实了，都是在…在空中楼阁上这么画呢。他在这个…到这个顶点他不辨，他，他不会辨。顶点是什么呢？方证！你像太阳病的发汗方子多少你说说，啊？大概我看一看，一满二十六个。你随便拿个方子发汗去行吗？绝对不行。那一个方子都是伤温伤寒，啊，外感风寒，啊，方用辛温发汗法儿，那就出来这个桂枝汤了？那不是瞎来吗？所以他这个书，好就好在这儿！原则上的能够立法。你比如说吧，太阳病，法当发汗，这是没问题的！怎么发汗？具体的事情具体分析。得辨到方证上，该用什么要用什么！他是这么一个书啊！所以研究这个…仲景书啊，你得有这么一种的，脑子有这么一种这个…认识，你才能对他有用。你看看白头翁，你看后头他说的，他说很多。

李冠杰：这条在《康平本》是降一字格排版的条文。下边解读：

“热利下重”，论述的实际是两个证。“热利”不仅论述了白头翁汤证的主要症状是下利，同时还阐明了下利的病理为里热证。“下重”是患者在下利的同时还伴有里急后重（中医经常叫里急后重），或者通俗地讲就是有明显下坠感的一种症状。这是白头翁汤证的一个

特征性的症状反应。

该条文也属于典型的简述，这里只有下利和下重两个症状，但在实际临床中白头翁汤证的症状表现还要复杂得多。但“里急后重”却是此方证中一个最具特征性的症状反应。据临床统计资料显示，发热、腹痛这类症状的实际发生频率比“下重”要高，实际中比有“下重”的人出现的次数还多，但这类症状在其他热性下利的方证中也都存在，比如在葛根芩连汤证中出现发热、腹痛这类症状的频率也很高，但“下重”这个症状在白头翁汤证中出现的频率要远高于其他类似的热性下利的方证，所以还是那句话，这是白头翁汤证的一个特征性的反应。因此该条文只是重点论述了这种典型症状反应，其他可能出现的诸多症状都包括在热利中了。热性下利可能出现的症状在这都包括，从药物组成也能看到这一点。

下面看看方剂，白头翁汤由四味药组成：白头翁、黄柏、黄连、秦皮。这四味药都是寒性的、收敛止利的药，并且都有清热除烦的作用。其中白头翁还有凉血行瘀，治疗腹痛、衄血、便脓血这类特殊的功能。《本经》中论述白头翁属于温性药，但实际临床应用中如凉血行瘀、清热解烦这都是去热的功效，所以白头翁应算作寒性药。秦皮在清热止利的同时还有收敛津液、止崩漏带下，治疗眼睛方面疾病（目疾）的作用。黄柏和黄连大家都比较熟悉了。这四味药合在一起对于里热性的下利就有非常好的治疗作用。另外跟其他类方比较，在该方剂中因为有白头翁（此药和血分有关系），所以如里急后重以及便脓血这类的特征性症状反应就比别的方证要突出一些。

下面是白头翁汤方证。在症状上出现频率最高的是发热，接下来依次是腹痛、里急后重、口渴、便脓血、呕吐、食欲不振、神疲、形体消瘦、恶心、小便短赤、面黄、畏寒、身倦、失眠、神昏、面赤。从这儿看，统计资料有时就比较偏于机械，毕竟数字是死的，但我们应该活着解读。这里补充一个很重要的症状，就是大便的时候肛门有

灼热感。实际在很多医案里都提到这个，但是统计资料里却没有，这个应该作为一个特征性症状。

舌质：红舌、紫暗舌和绛舌。

舌苔：黄苔、白苔、白腻苔，其中黄苔最多。

脉象：弦脉、数脉、细数脉、沉脉、滑脉，另外还有长脉、濡脉、虚脉、弱脉、微脉。

现代应用：痢疾、细菌性痢疾、阿米巴痢疾、滴虫性痢疾、原虫性痢疾、急性胃肠炎、慢性胃肠炎、浅表性胃炎、肠炎、结肠炎、溃疡性结肠炎、坏死性结肠炎、肠伤寒、肝炎、黄疸型肝炎、肝硬化、阿米巴性肝脓肿、胆囊炎、短暂阵发性室性心动过速、室性早搏（关于心动过速和早搏这类的病在现代医学看，因为现代医学没有寒热的概念，它关注的是体表温度和体内温度，像中医里这种寒热的概念它没有。但是心动过速按照中医讲就是脉数，说到这里中医人几乎都明白，造成脉数的原因有很多，有热可以造成脉数，人虚了有时候也能造成脉数，有表证发热的时候也可能造成脉数，很多情况下会造成脉数。所以实际上有时心动过速跟心脏无关，当然假如确实查出心脏方面有问题、有一定病变倾向的是另一种情况。因此很多情况下，现代医学对心动过速这类疾病就没法解释，但在中医看来就非常清晰。）、神经性头痛、抽搐、肾盂肾炎、前列腺炎、肾积水、耐青霉素霉菌性尿道炎、泌尿系感染、盆腔炎、阴道炎、宫颈糜烂、赤白带下、盆腔脓肿、乳房肿块、产后血淋、红眼赤痛、急性结膜炎、病毒性角膜炎、黄水疮。这里个别还有中医的病名，只要有利于理解该方证，就把它拿过来。

下利腹胀满、身体疼痛者、先温其里、乃攻其表、温里宜回逆汤、攻表宜桂枝汤、①（372）

注：《宋本》此处有桂枝汤方及方后注，此从略。

胡希恕：这头前儿都讲过，对吧？“下利，腹胀满”，他虚胀虚满，啊。那么这是一种阴寒下利。“身体疼痛者”，这有表证。这个痢疾呀，一来呀，常常的有外…有表证，啊。有表证他表证不明显。你像咱们头前儿讲那一个“太阳阳明合病必下利，啊，他用葛根汤主之”，他所现的是葛根汤证，那恶寒的很呐，啊，脉紧无汗，啊，头痛。这一个他都没有，他只是身上疼而已。那么他这一个主要的是什么呢？他是阴寒下利，他这个是没说“下利清谷”啊，准是“下利清谷”。这一个我们要舍表救里，啊，先温其里，乃攻其表。这一个里头虚，里虚寒，越攻表越坏。温里宜四逆汤。攻表宜桂枝汤。这头前儿讲过的。啊…这个桂枝汤也讲过的，啊。

李冠杰：这条在《康平本》里也是降两字格排版的条文。在《宋本》条文最后有桂枝汤的方剂和方后注解，《康平本》里没有。

下边解读一下：

直译：下利如果同时表现为腹胀满、身体疼痛的，应该按先温里后解表的原则进行治疗。温里适宜用四逆汤，解表适宜用桂枝汤。

该条文实际是对经方理论中这类治疗原则的重复和强调。学习时重在理解其中的治疗原则，而不是机械的解读。比如上述这类情况，有时存在可用桂枝人参汤表里双解的机会，所以不要机械的去学习其方法，而是要加深对经方在该情况下要先温里后解表的治疗原则的理解就够了。

下利欲饮水者、以有热故也、白头翁汤主之、（373）

胡希恕：所以这个，“饮水”呀，啊，这就是“下利而渴”。这一个饮水不像白虎汤那个渴，那一个欲饮水数升，白虎加人参，是吧？没那么渴，他可是“口干口渴”，他有热么，啊，哪儿有热？里有热。他这热上炎，他口就干，就渴。所以这个阴病啊，都口中和，啊。如果下利，啊，渴欲饮，这是热，纯粹热的关系，啊。这一个用白头翁

汤没错的。白头翁汤这一个痢疾呀，不光口渴。这个病人呐，他也说呀，这个下利呀，烧得慌，啊。这都是他的证候，它都苦寒药嘛，它四味全是。如果热到里实的证候，白头汤就不行了，底下说了。

李冠杰：这也是降两字格排版的条文。

直译：下利而且表现为欲饮水的，是由于有里热的缘故，此为白头翁汤主治之证。

该条文论述的是白头翁汤证另一种比较典型的表现形式，以下利和渴欲饮水为突出的症状反应。因为后边有治疗方剂，前边也有治疗方剂的论述，所以这里实际就包括了白头翁汤证的诸多症状反应。该条文论述的重点是：有时白头翁汤证表现为以下利和渴欲饮水为突出的症状反应。临床统计资料也显示白头翁汤证中口渴的症状出现的频率比较高，但在其他治疗热性下利的方证中口渴这类症状都没有这么突出。

下利谵语者、有燥屎也、宜小承气汤、①（374）

注：《宋本》此处有小承气汤方及方后注，此从略。

胡希恕：那么热到…啊，里实之后了，白头翁就不行了。他底下就说。“下利，谵语者，有燥屎也。”这个“谵语”在阳明病篇讲了很多了。是“谵语”，都是胃…不但有热，它实了，啊，大便硬了。那么这是什么呢？他吃着的，里头有宿食。这一个用小承气汤。要如果热的明显用调胃承气汤。比方说他有潮热，是吧？身上蒸蒸的发热，也谵语，那个用调胃承气汤。大承气汤用的机会很少，啊。小承气汤呢？也就是大便…啊，虽然他下利，可是内里有燥屎，这个你摁他肚子，他拒摁。咱们以前儿有一个老大夫，叫陈慎吾啊。他的母亲呐，有一次就得痢疾。得痢疾呀，她们家病净我给看。啊…老太太得痢疾，好，一个来月他也没敢吃泻药。她的姐姐信…信这个邪门歪道的，尽给赐符，哈！后来呢，陈慎吾一看不行了，他就找我。找我我就去了，

去了一看，好家伙，那个舌苔，那个黄，那个干呐。我就让陈慎吾，我说你摁摁老太太肚子，我说你从这个，啊，心口往下摁，他将一摁心口，老太太拿手直推，嘿，嘿，嘿！我说没关系，我说这个可以吃承气汤。吃这个，吃一副就好了。泻，她那个拉了一宿干粃粃蛋子。学名可是痢疾，她那个内里有燥屎，它下不来，痢疾也是蹲肚得不得了。所以古人说这有燥屎，这是一点儿不错的。痢疾哪来的燥屎啊？就里头他有，啊。他胃，他上边结实。那你要拿手要摁。所以这个虚实，啊…你非要把它，啊，把它诊察清楚。这个谗语与燥屎，这是一个，啊，燥屎的一个很要紧的一个证候。

胡老：你们老太爷，说胡话，不都是这个事儿么！

学生：也腹痛拒按？

胡老：哈，哈，哈，哈！

学生：也是腹痛拒按。

胡老：啊！就是啊！我给…头…开始给吃泻药就是因为这个问题。这个谗语没有虚 证啊。尤其他的舌头，好家伙。

学生：对，对，对！

李冠杰：这也是降两字格排版的条文。《宋本》在条文最后附有小承气汤方和方后注解，《康平本》里没有。下边解读一下：

直译：下利并伴有谗语的，是由于里有燥屎所致，适宜用小承气汤治疗。

该条文论述的是在里实证的病理状态下发生下利的一种情况，这就是后世所谓的“热结旁流”一类的。凡是谗语，多数都是因为里热所致。对于下利的同时又伴有谗语的，还应该注意有没有里实证的存在，这就是该条文论述的重点。如果有，就应该用小承气汤这类的方剂治疗。

这种情况在临床中一般需要做腹诊。这类病人做腹诊，用手按肚子就会有明显的疼痛感，里面有抵抗感，而且拒按，按就疼得厉害，

不让你按。

下利后更烦、按之心下濡者、为虚烦也、宜栀子豉汤、

①（375）

注：《宋本》此处有栀子豉汤方及方后注，此从略。

胡希恕：这个下利后跟我们上面说那个下利后是一样的“下利止后”，他本来不应该烦，而还烦。这个烦就是热了。看看这个虚实吧，摠他这个心下，就是当胃这个部…部位，濡软，啊，无力，那里头是无实，那就没有燥屎啊，啊，没到这个胃家实那个程度啊，所以他说是“虚烦也”。那就可以吃栀子豉汤就行了，啊。到这儿呀，这个下利讲完了，啊。啊…下一次啊，咱们把这个厥阴篇整个讲完，我把这个三阴三阳篇，咱们作一个总结谈一谈，啊。啊…很重要，一…大概，我多费点时间，把它谈完它。

李冠杰：这条也是降两字格排版的条文。《宋本》在条文最后附有栀子豉汤方和方后注解，《康平本》里没有。

直译：下利止后，患者更加烦躁，腹诊按之心下濡软的，为虚证所致，宜用栀子豉汤治疗。

该条文论述的是下利愈后出现虚热证的一种情况。此处的下利，一般来说是热性的下利，或经过治疗，或没经过治疗，自愈了。

总之是下利好了以后，可还有余热未除，而此时人体因为有下列的经历，所以就陷于一种比较虚的状态，在这种情况下人体就容易形成栀子豉汤证的虚烦证。

条文中用栀子豉汤而没有用栀子干姜汤，至少可以知道以下两点：第一，此时患者下利的症状已经完全消失了，甚至连大便偏溏也不应该有，如果有的话，那就应该用栀子干姜汤；第二，此时患者必然得有明显的其他热象证候，比如脉数、苔黄，或者虚烦不得眠等。因为栀子豉汤有缓下的作用，所以这里用了栀子豉汤。作者既然写在

这儿，必然是在临床过程中有过治验，假如我们再去用，像这类条文需要客观的看，应该在有符合栀子豉汤证的病理特征下才能用栀子豉汤。因为前面有个下利的过程，如果真正存在大便偏溏、偏稀，下利还没完全好的情况，那使用栀子豉汤的机会可能就不是很多了。

呕家有痈脓者、不可治呕、脓尽自愈、（376）

胡希恕：（音频缺如）

凡呕吐者，若所吐有脓，乃内有痈脓的病变，依法当排脓，慎不可治呕，脓排尽则呕自愈。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。

下边解读一下：

直译：平常就有呕逆的患者如果有痈脓的，不能治疗其呕吐，待脓吐尽了，即可自愈。

“痈”原本是指皮肤和皮下组织的化脓性炎症这类的疾病。该条文论述的是平素就有呕逆证的这类患者，如果胃中或食道内发生化脓性的痈（化脓性的炎症）没得到合理治疗而造成痈脓溃破，并且人体要以涌吐的方式将脓排出体外的情况。“呕家”是指平时有呕逆的人。本来平时就有呕逆的倾向，如果此时再加上消化道内有痈脓溃破的情况，所以身体要把脓排出来而形成呕吐的机制，再加上患者本身就有呕逆的情况，那么这个呕吐的症状就会比较重、比较明显。但此时的呕逆，实际是人体通过涌吐的方法排脓的一种自愈机制，所以即使平素就有呕逆证的患者，在这类情况下也不能用止呕的办法来治疗。当然这时虽然有呕吐的病理机制，但也没有使用吐法的机会。因为这时的呕吐实际是要将脓排出体外的一种呕吐，有脓就吐，没脓就自止不吐了。因此，要是止吐就会影响痈脓的排出；要是催吐（加快疾病痊愈）反而会致人虚，一般有痈脓的人本身就有虚的倾向，反倒会影响痈脓的痊愈。所以条文说“不可治呕”，随着痈脓的痊愈呕吐就会自

止，“脓尽自愈”。

如果客观深入地思考，这里虽说“不可治呕”，但如果能对症用一些排脓的药（合适的方剂），那肯定对疾病的痊愈是有好处的。

呕而脉弱、小便复利、有微热^①、见厥者、难治、回逆汤主之、（377）

注：“有微热”《宋本》作“身有微热”。

胡希恕：……啊，就不能制水，其实这…这是一个古人的这么一个看法，这是个规律，是吧？胃虚，小便，啊，频利的多。所以胃虚的厉害时遗尿啊。咱们用那个甘草干姜汤治遗尿，也就从这上来的。苓姜术甘汤也是的，啊，他从干姜甘草变化。就是干姜甘草加茯苓白术，啊，他是甘草干姜，也就是理中汤的一个底子嘛，也就是理中，啊，利尿，治那个小便频。那么这一节儿他就说“呕而脉弱”，都是胃虚，胃虚到一个极点，他就不能够治下，就是，也使着这个，啊，小便频数。“身有微热见厥者难治”，他由于里虚寒，这是个，开始我就说他是太阴病的一个表现了。那么阴寒之极，这个虚热呀，反倒现于外，这最坏的现象，是吧？啊…咱们后头要讲这个“霍乱”的时候那最清楚了。就是咱们古人说的这个，啊，无根之火了。他有微热，按理说不应该有微热。“而见厥”，厥，呕而脉弱，再厥，这是胃气沉衰，啊，这个谷气不能布于四末了嘛。那么这一个病看着就像挺…啊，呕而脉弱，小便自利，身有微热，见厥，就像不怎么的似的，这个病，啊，其实这个病啊，主要是“身有微热”。“身有微热”这是这个，内里头这个阴寒之极呀，啊，这一点这个，余阳啊，净现于外，这是最，啊，因为这一个再见厥，所以这个病啊，是不好治的。那么也有，啊，只有四逆汤这一法了。四逆汤他还是，这个所谓……（音频缺如）

李冠杰：这条在《康平本》里也是降两字格排版的条文。条文中

的“有微热”在《宋本》里是“身有微热”，明显比仅是“有微热”合理一些。解读一下：

直译：在呕逆证的同时又表现为脉弱，小便复利，且有微热、厥利的较为难治，用四逆汤治疗。

该条文论述的是一种比较重的呕逆。“呕”是由于里虚证胃气不降出现的一种呕逆证。“脉弱”说明里虚寒证比较严重。

条文中“小便复利”的病理机制应该不是一般的小便畅通，不是那个样子。这里小便频数的病理机制是在里虚寒证这种病理状态下，尤其表现为对小便控制能力的下降，与甘草干姜证中的“小便数”是一类比较相似的症状反应。

“有微热，见厥者”在《宋本》是“身有微热，见厥者”，就是指在体温偏高的同时还表现有四肢厥逆的症状，这是典型的阴性里虚寒证的症状反应。

接下来“难治，四逆汤主之”，条文中本身这种矛盾的论述可以说明两个问题：第一，该条文的作者很可能有用四逆汤治愈此类患者的亲身经历；第二，虽然是以四逆汤来治疗，在治疗方向上对于里虚寒证不能算错，但方与证并不十分相应。整体从述症看，这里至少还有甘草干姜汤证，假如与甘草干姜汤合方或许疗效比单纯用四逆汤要好一些。另外大家再想想，甘草干姜汤和四逆汤合方后药味是没有变化的，只是药物比例有变化，甘草的量增大了，所以特别适用于这一类的情况。

干呕、吐涎沫、头痛者、吴茱萸汤主之、①（378）

注：《宋本》此处有吴茱萸汤方及方后注，此从略。

胡希恕：这个病很多了，“干呕”就是不吐食，但是只吐涎沫。涎沫就是这一个，啊，这是胃有停水，他上来一种这个，所吐这个不过是涎沫而已，也是水了。“头痛者”，这个水气往上来，它冲逆他

才呕吐涎沫呢。那么是水气上冲啊，都影响脑袋，脑袋痛啊，脑袋晕呐，啊，他这没说头晕。我就根据这一个，我治头晕，我常用吴茱萸汤。只要是，不一…不一定吐涎沫。我们问这个病人呐，口水多，啊，那么这也是这个寒饮往上漾的一种表现；或者是胃痛，啊，他这个胃虚停饮嘛。这个，这个水究其实在胃呀。这个用吴茱萸都好使的。咱们一般说这个美尼尔氏证啊，他只要是晕的呀，动也不敢动，一动就要吐。那肯定是吴茱萸汤。这一个方…这一个…这一个方子最常用的方子了。这个吴茱萸这个药啊，它就是去这个水往上，啊，冲逆，是最有效不过的。这个药不过它热一些，啊。因为祛水的药都得用热药，你像干姜啊、生姜啊，啊，全是的。是有胃水，胃…都由于胃虚，那么另外呢，他搁上人参、大枣、生姜。这个吴茱萸配合生姜呢，这个生姜量也挺大，他为之治呕了，止呕去水；人参、大枣呢？啊，它还是健胃补虚了。这个胃不虚，它不停水。所以胃虚呀，这个水它自然就往上上。咱们讲那个甘草泻心汤不也讲过了嘛。那么“心下痞硬”，那个这一个方子也有“心下痞硬”，他有…有人参嘛，人参三两。那么这个书上他是没…写出来，因为它不是一个主要证候。那甘草泻心汤有，啊，他就因为这个，啊，汗下太厉害了，客气动膈。他胃虚了，这个“客气”，客气指的多了，一方邪热的客气，一方面水也往上来。这时候这个，胃这个部位就是摠着“心下痞硬”，痞硬里头净些坏东西，净是，啊，客邪、水气，啊，他不是真正胃里头有实，生生的…到不是那一个。他就是有些这个属于水气，啊，或者热邪，心下痞硬。那正是一个，用人参的一个主要证候，啊。就是胃虚才有这个情形。咱们讲阳明篇不有这么一段嘛，“心下痞硬者不可下之。”那么下之呢，利遂不止者死，是吧？那一个就指着是人参证，那根本那指的是理中汤证，理中汤证就心下痞硬，那你需要健胃补虚，你再下，下，利遂不止，啊，那人是不可救了。如果幸而利止，还可以救。所以他说，啊，利止者生、利止者愈。所以我们在临床上啊，遇着心下痞硬，

心下痞硬有实有虚呀，不是净虚，啊。真正的你像那个大承气汤证，啊，他这个硬啊，摠着，他拒按。那个注家他不这么讲的，啊，就我方才说那个…阳明篇那…也是。他说的呀，这个大承气汤泻腹不泻这个心下。嘿！心下实不能够用大承气汤，那下利，就要下利不止，这是胡说。他究其实真虚，啊。那么这一段呢？他由于胃虚才停水，一方面去水用吴茱萸、生姜，止呕；一方面也固其根本呐，这个胃要不恢复，你只祛水也没用，是吧？去水把它…由于胃虚，水还来。必须得，啊，这是标本兼治了，一方面下其寒水，同时用人参、大枣补益胃气。他指这个方子意思是这个。这个方子很常用，这个病也很常见，啊。

李冠杰：这条在《康平本》里是降一字格排版的条文。

前面已经有两条关于吴茱萸汤证的条文，这里实际论述的是吴茱萸汤证在临床中的另一种表现形式。

“干呕”，指的是在里虚寒证比较严重，同时又伴有胃中停饮的病理状态下的一种症状反应。

“吐涎沫”，指的是胃中有寒。吴茱萸汤证的胃中停饮的机理是：由于胃对水的吸收能力下降所造成的。方剂中的四味药都是治疗胃虚并有改善胃对水的吸收能力的。但从药物上能看出，吴茱萸汤中有大枣，特别是有人参，人参是增加津液的，方剂治疗的又是胃中停饮，因此可以得出结论，此方剂治疗的是因为胃对水分吸收功能不好的情况。但是其他的一些水证有时也表现为不渴，舌质水滑之类的，这种情况也挺多，但不一定“吐涎沫”，这也是一种停饮。针对这种停饮的方剂比如泽泻汤，其中两味药都是祛水的，虽然也有改善胃功能的一面，但是在明显改善胃功能方面肯定不及人参。所以这里面还是有区别的。

“头痛”在吴茱萸汤证中是个典型的症状反应。吴茱萸汤证不仅表现为头痛，还常表现为头晕。如现代医学中的美尼尔氏症，这种病

以呕吐头晕为典型症状反应的患者很多，因为对其致病机理没有确切的认识，所以现代医学把它命名为某某综合症。中医对其也有一些解释，如水气上泛之类的，笼统地说原则上也没有问题，但具体的机理是什么？为什么只有吴茱萸汤证出现特别明显的“头痛”？这些到目前为止，我们也找不到一个令人满意的解释。

这条实际就是降一字格条文作者对顶格条文中有关吴茱萸汤证内容所作的一个补充。顶格条文第 243 条“食谷欲呕者、吴茱萸汤主之”，第 309 条“少阴病、吐利、手足逆冷、烦躁欲死者、吴茱萸汤主之”，再加上本条降一字格排版条文的“干呕、吐涎沫、头痛”的症状，整个吴茱萸汤证就比较全面了，此外根据实际临床所得，还应加上“头晕”。这种加，不是要加全后固定成吴茱萸汤证的意思，而是在学习吴茱萸汤证时就应知道上述这些典型的症状反应。

作个小结：以干呕、吐涎沫和头痛为主要症状反应的，为吴茱萸汤主治之证。

前两天有个在我这儿吃了一段时间药的病人，我对他的身体比较了解。因为前一段时间就出现过吴茱萸汤证，吃了就好了。这次突然打电话来，我问：胃里感觉有什么不舒服吗？他说：胃里有点满。我问：你吃凉东西了吗？他说：吃了西瓜。我就给他吴茱萸汤。这时已经是下午了，到晚上吃饭后他才吃药，然后发短信说：现在头疼的很严重，感觉就是要死的样子。本来我让他服的量也不是特别大，我就让他再服了一次。到了第二天就好了，这一宿睡得特别好、特别深，但是醒了以后头脑有点空空的感觉，随后吃了饭慢慢就没事儿了。

呕而发热者、小柴胡汤主之、①（379）

注：《宋本》此处有小柴胡汤方及方后注，此从略。

胡希恕：这一个在太阳篇已讲过的了。所以这个发热呀，这个小柴胡汤这个解热力量相当的好。那么凡是这个呕，咱们讲那个柴胡剂

的时候讲过，说是柴胡证啊，啊，见着一证即是，不必悉具。这个心烦喜呕，这个呕是个，啊，柴胡证的一个主要证候，他这四个证候里头啊，往来寒热，啊，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，这是四个主要的证候。那么如果要是发热而又呕，啊，肯定这是，啊，少阳病，啊。少阳病，这也是三阳病之内，这是发热了。所以要用小柴胡汤。那么也就是“呕”是一个证候。根据不同的，啊，这个其它的脉证，那么治疗是不一样的，啊。所以咱们辨证也是这样子，那么它这个书就是，通过六经，啊，还再辨八纲，就是分这个虚实寒热了，那么最后呢？还得到方证上。方证就是个方剂的适应证啊。你像这几个呕，他这治疗是各有不同。这四段呐，就是论呕。那么，啊，头前儿呢？他是这个，前二十八节儿他就论的厥，四肢厥逆那个厥；那么再以下他就论的这个下利；在这这是论呕。很清楚。他这绝不是厥阴病。看就看出来了，啊。所以在这个，我开始讲的时候就说了，那么在这个诸四逆厥以下呀，这在《玉函经》这是单独一章，就是辨厥、利、呕、哕四个病形脉证并治，这个是对的。那么王叔和呢，把它搞到这个厥阴病篇里头了，这害人，啊。当然仲景在这个三阴三阳篇之后，他另有用意了，这个我也讲了，啊。啊…可是他这一搁呢，这个注家就是…把这个厥阴病说得就热闹了，啊。他认为这都是厥阴病。这个厥阴病就没法辨了。

李冠杰：这条在《康平本》里是降一字格排版的条文。在《宋本》条文最后附有小柴胡汤方剂和方后注解，《康平本》里没有。

这条论述的是小柴胡汤证另一种较为典型的表现形式。这儿的述症与之前顶格排版条文的论述没有质的区别。小柴胡汤顶格条文里就有“心烦喜呕”，虽然这条述症比较简略，但这个“呕”就是“心烦喜呕”中的一个症状。

“发热”这个症状在小柴胡汤证顶格条文中也有多处论述。比如“身有微热”在第 96 条里；“身热恶风”在第 99 条里；“发潮热”

在第 104 条、第 229 条、第 232 条里都有论述。这条论述的虽然从症状看似乎是顶格条文已经包括的，但其论述的重点不是要重复顶格条文的内容，而是要强调小柴胡汤证在临床中有时会以“呕”和“发热”这两种症状为主要症状反应表现出来。这类情况在实际临床中也是比较多见的，比如一些无名低热有时会伴有恶心甚至呕吐，另外一些高热的患者伴有恶心呕吐这类症状时服小柴胡汤的机会是比较高的。

小结：以“呕而发热”为主要症状反应的，为小柴胡汤主治之证。

伤寒、大吐、大下之、极虚、复极汗出者^①、其人外气怫郁、复与之水、以发其汗、因得哕、所以然者、胃中寒冷故也、（380）

注：“复极汗出者”《宋本》作“复极汗者”。

胡希恕：380 条儿，“伤寒大吐大下之，极虚，复极汗者”，那应该有个“出”字儿，“复极汗出者”，你添上。他那后头也注了，《玉函经》就有“出”字儿。“其人外气怫郁，复与之水，以发其汗，因得哕。所以然者，胃中寒冷故也。”这个伤寒，啊，太阳伤寒他应该发汗嘛。“大吐大下之”是误治了，啊，这给治错了。那么里头没病，大吐大下之呢，所以“极虚”。极虚就指着胃说的，啊，里边，里极虚。“复极汗出者”，这个虚人，啊，尤其咱们这…入于这个三阴病了，这个他指着太阴了，他不会再出汗了。所以“复极汗出者”，它这往下说的。这就以其人呐“外气怫郁”，“外气怫郁”就“身有微热了、颜面潮红了”，这都是，啊，“外气怫郁”。这一个“外气怫郁”是不可发汗的，啊。可是这个医…这个大夫啊，他给他“复与之水，以发其汗”，所以，因为这一个，其人这一个，啊，“复极汗出”。这个汗出呀，是由于以水发汗。以水怎么能发汗呢？这个以水发汗呢，这一个，正经医疗上也有的。你像我们这个茶叶水就发汗。有的这个感冒啊，就嚼点茶叶，喝点冷水，就发汗。那么古人他也有

这一个法子，他这个大概不是用那个吧。这个他就是给他喝热水，温覆取汗，总是这个意思，他看起来极虚嘛，他不能发汗。可是这一个呢，就使他一种虚脱现象，啊。这一捂，啊，他由于大吐大泻之后，这个大吐使之内烦，内里头也有热，啊，咱们头前儿讲过了。那么“外气怫郁”，啊，那么就是有表证，真正到这个里极虚之候，也要舍表救里呀，没有发汗之说了。这个咱们也讲挺多了。那么就是外气怫郁这一个时候，啊，冲这个“极虚”两个字，也就不管他这个表了。这一种表也兴是“浮阳外越”，就像我们头前儿说那一个，难治那个呕是的。所以我们在临床上啊，这是要紧的。咱们讲那一个“阳气怫郁在表”，啊，在阳明病篇呢，解释要“解之，熏之”。解之、熏之就像用呢…他因为不得小汗，所以阳气怫郁在面。那么就拿这个轻药，我们头前儿讲的那个，啊，麻黄桂枝各半啊，或者麻黄…桂枝二麻黄一呀，啊，桂枝二越婢一呀，这都是一个，啊，“解之”使…使得微汗的法子，也得根据，根据证候啊，啊，看什么方证，用什么方子就对了。但是那一个他里头不极虚，你可知道。所以这个，这一个，读这个书啊，你前后，你非得好好看看不可。那一个他不是极虚，所以你吃那个药还都行。这一个他是极虚，可这个书他没说明。他没说明，他不必说，他…他给…给你读书的人呐，指出来了，他说这里已极虚。这一个“浮阳戴面”，啊，或者“身有微热”，你不要发汗。这就是，就是这个口气就在这呢。那么复与之水，再温覆取汗，这是错误。这一个“复极汗出”这是一个脱汗。而且这个水停于胃，啊，这个胃虚寒，从底下这个“胃中寒冷”这几个字，我们知道这个“极虚”呀，就是太阴那个极虚。这个胃极虚，水再饮下去，水性寒呐，啊，胃中虚冷一定要逆不止的。这一个在头前儿在这个阳明病也讲了。

李冠杰：这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。条文中“复极汗出者”在《宋本》里是“复极汗者”，《宋本》比较合理些。

直译：本为伤寒病，医者反以大吐大下的方法治疗致人极度虚弱，

然后又使其极度汗出，患者出现外气怫郁，而又让其大量饮水并以此促使汗出，因而发生了“哕”的症状，这是由于此时患者胃中虚冷的缘故。

这条论述的是对表证的患者先误以大吐大下的方法治疗，然后又用了发汗的方法，致使人体里外俱虚。由于津液损伤，所以患者必然会表现为渴欲饮水的反应。此时假如没有其他的症状，按照以前的论述本应是“少少与之”，少量地、一点点地喝水，让津液慢慢地恢复。但这里却是让患者大量地饮水，因此都出现了汗出的效果。这时因为之前的误吐误下已经致人体胃肠功能比较低下了，又再一次大量饮水，一时无法吸收，就造成了水停胃中而发生哕逆的症状。

伤寒哕而腹满、视其前后、知何部不利、利之即愈、（381）

胡希恕：这个哕逆呀，哕就是我们说这个呃逆。也就是说干呕这一类的，啊，他不吐东西，光有声儿，啊。不过这个哕的这个其声儿连连呐！啊。啊…惊人！这个就是，啊，这个胃虚寒的时候多。但是也有实证，他这一…最后这一节儿就说明这个。那么这个气不得下行，它往上来，所以他说是“视其前后，知何部不利”。所以我们要遇着这个哕逆之病啊，虚的固然多，也有实证。如果大便不通，啊，而哕逆，你通大便哕逆就好，这气不得下行。小便不利也可以使之哕逆，那你利其小便就可以好。所以这个，任何一个证候片面看问题都不行的。这个哕，咱们头前儿有很多节了，虚的多，可不能说见着哕就是虚。就像我方才讲那个，啊，“外气怫郁在表”呢，啊，那是表，可是你看他这个，没有这个里虚极虚之候，那你用小发汗法儿行的，啊。换言之，饮水让他发点汗也可以的，不是不行。但是极虚之候，非舍表救里不可。那就不行了。所以我们在临床上啊，啊，片面来定这个治疗的方法，这是十九是错误的，非全面看不可。他这个书啊，你看看，一开始，无论是辨太阳病、辨阳明病，都是辨太阳病脉证并治，

啊。他注重主要的他是，你处处得看脉、证啊。你不能够拿一个证候就定全局了，这是不行的。

李冠杰：这条是降两字格排版的条文。

解读一下：

直译：患伤寒后表现为“哕而腹满”的，需诊查患者的大便与小便，若有不利情况，对症利其大便或小便即可痊愈。

这条论述的是在表证的同时又出现了“哕逆”的症状，同时还有“腹满”，也就是说“腹满”和“哕逆”是一个有内在联系的两个症状。凡是这类情况应该就是因为水证（停饮）或者里实证造成的，可以通过进一步诊查二便来确定病因到底属于哪一方面。若大便不利，那就是因为里实证造成的；若小便不利，那就是水证了，可以用适当利尿的方法治疗，治疗以后就好了。

六经辨证略说

胡希恕：那么这个…这个《伤寒论》这个辨证啊，在这个书他是以六经来分的。所以大家都知道六经辨证，嗯。但是他这个书前后呢，全是说的是表里阴阳，啊，寒热虚实，是吧？他既有六经又有八纲。那么我们研究他这个书，首先你要把这个六经八纲把它搞明白。那么这一个东西呀，我们就得，啊，不能违背历史喽。我们要看看这个中医呀，他怎么搞出这么一套辨病呢？啊，他怎么不像西医现在辨病啊？这就是大家这么…这一个，这个中医这个发展这个时代，太古了，啊。起码…你像我们这个书差不多一千七八百年了，那么他有这么样…你像这个书，这么样子条理清楚，可见中医的发展呐，比他这还要早得多，啊，那最迟也得追溯到两千年以上。那么，那一个时候，咱们一想就可以知道的，那一个，啊，那一个，那个当时的历史，啊，这个历史的情况，他没有科学，啊，科学就是还不进步吧。更没有更好的器械。现在人西医的病名啊，不是随便说的，啊。什么病毒啊，什么病菌呐，有什么病原体，啊，而在生理上形成某处、某处发生什么、什么的病变。那古人他怎么搞这个呀，他是不可能。所以古人呐，没法认识病。他没有更好的器，医疗器械嘛，他也没有 X 光，也没有显微镜，他哪儿看病菌病毒去呀！就是局部病变他也看不出来呀，啊。所以他也是，势必促使在这个疾病反应上看问题。在疾病反应是什么玩艺儿呢？那较比现在的话就是证状。这个东西是很，很不简单

个事儿。他加之时间呐，所以中医的发展远去了。那不是…不但不是一个人，也决不是一个时代，他经过长久的观察呀，啊，他观察一种病也不行啊，他得观察多种病。他观察出来呀，一套的这个疾病这个发展过程上啊，有一种规律。这是了不起的一个事儿啊。我们讲这个六经什么，都是规律。那么在…他这个，进行疾病的观察呀，也促进这个人的对这个证候的分析能力，所以咱们说搞出四诊来了呢，这是自然而然的。你像我们方才说那心下痞硬，有虚有实，摠之痛者为实，不痛为虚。这都…这…这个他都是对这个病的这个…啊，一个证候，他能够分析到这个地方，这说明中医四诊的他这个进步啊。他是一点点进步，也…啊，对于脉，也不是看看他的快慢而已了。他从脉这个跳动上，在这个脉体的变化上，在这个血行的变化上，他非常的细。他就促进他这一套发展。那么时间久了，他们在疾病看着一种一个规律。这个规律呀，是不可改变的规律，要不他不会治病的。这一个咱们现在讲，是较比容易。那么古人这个发…发现这个相当的…相当的，那是千难万困了。不但他看出来疾病有一个，一般的规律，而且在这个规律上啊，他传承一套东西。就什么？就是咱们所说这个，啊，治疗的法则，应用的方剂，全是从这里头，他弄出的结论。那么这一套东西呀，是客观存在的，他通过实践嘛。他一点一点的试验，一点点的试验，对于药物的配方啊，啊，对于这个药物的这个性能啊，他也都熟悉了。那就是一…那开始那人当然是了，拿人试验了，他拿什么试验？哎，他做出一套结论来。这种结论呐，是客观存在的。可是这一种结论你怎么来认识它？这个古人难了。我们想一想，疾病所反应的全不外乎病理、生理的问题。这是属于科学范畴。那古人他没法认识。所以没法认识怎么办呢？他还还要认识，他就是主观测想，这是肯定的，啊。再不就拿现象儿当本质。你像咱们说这个中风伤寒全是的，啊。你像中风证他一定恶风，他出汗嘛，翕翕恶风，他就说这是有风邪。这是拿现象儿当本质了，这是错的。那么他这个规律呢？

那是客观存在的。不是…啊，所以我们现在研究他，还有这个，啊，现实意义，就在这儿。他这种规律呀，不但古时候这样子，现在这样子，未来恐怕还是不会变的。它是客观存在。所以我们研究这个，啊…古人这套东西呀，先要把这一个搞清楚，一个是规律，一个是他这所说的这个规律的认识。那么这种规律先前在哪儿呢？那么最原始，也像我们这个《本草》一样，他也有登记一种最早的一种典籍，那就是所谓《伊尹汤液经》，啊。因为这一套的结论呐，都在那一个书上。那么这一个呢，是伊尹发明的吗？当然也不是。就像我头前儿说的，那不定多少人呢？逐渐积累起来的。我们要如果信有那个圣人那就，那就好办了，要唯心主义，这个事儿啊，好解决，那他天而生之嘛，是吧？圣人参天地造化之妙，他就出来这个东西了，那就完了。所以以前也没人敢反驳，驳了你就污圣，啊。那还了得！是吧？实质他…咱们现在不信有那一个人了，所以这个书呀，也不是一个人做的。既不是张仲景，也不是伊尹。那么伊尹那一个，他怎么叫《伊尹汤液经》？我们一想就知道，跟我们那个《内经》现在咱们说是《黄帝内经》，是吧？本草说《神农本草》。他那个时候，就是我们当时生在那个时候，也不知道谁发明的。他有这个记录，这是肯定的，啊。这个记录啊，也就是记以前的人的大称。啊，拿着一本儿书，你像《神农本草》也是，《黄帝内经》也是，《汤液经》也是。是谁做的？做书的人他也不知道。他就得往前想，啊，那一个他是封建社会嘛，只能把这个功德的事儿啊，搁到帝王身上，搁到宰相身上，他不会搁到一个穷人身上的，是吧？那是历史的问题。所以张仲景啊，他是一个《汤液经》的一个，啊，这是杰出的这么一个传人了。哎，他就是根据《汤液经》他搞这个东西。这一个在这个晋的时候皇甫谧，他在这个《针灸甲乙经》里说得很清楚。说是“仲景论广汤液为数十卷用之多验”。那么张仲景他也不会，谁也不会一个人发明的。这个中医这个，这个由…啊，原始到这一个《汤液经》这个阶段，那很长的历史时间呐。那绝

不是一个短暂的时间。那么张仲景这个，他就是依据这个《汤液经》来的。所以咱们这个《伤寒论》呐，这个序儿是个假的。你就拿这个皇甫谧这个序言就可以看得出来。怎么讲呢，我们看他相距的年头儿就知道了。这个王叔和是魏末晋初的人，他是…这个皇甫谧是晋初的人，他们两个人极相近，那么他这个书，这个皇甫谧是看着的，如果有这个序儿的话，那皇甫谧还能够，人家说是撰用素问九卷，啊，八十一难，阴阳大论等等的。那皇甫谧说呢不是，啊，它序儿他也不信，啊，他说是这个撰用素…撰用这个这个，这个，啊，啊…，论广汤液为数十卷，不会的！可见在皇甫谧那个时候啊，这个序儿还没有，他就没见着这个序儿。那么他与王叔和相当的近呐，可见这个序儿，据我的推测呀，总是在南北朝，或者在五代的时候才有，以前就没有。所以这个，这个序言现在大家也都不跟他了。可这个序言耽误人耽误大了。那么对于这个《伤寒论》的这个注解，从成无己开始，他就根据《内经》来注的。牵强附会呀，所以把这个…这个书啊，啊，那么，在我学医那时候还是呢，用这一个方子的人很少。他怎么？他弄…弄不清楚。就这个序言害人害得相当厉害。这一个我们根据历史啊，对这个书啊，我们应该有这么一个认识。这一个绝不是张仲景自己独出心裁的著作。它是历史留下来的。尤其我们方才讲的那个厥阴，厥阴证，啊，厥阴病，它就那么四条。这个张仲景为什么他把这个治厥阴的这—种方剂他一个儿也不附呢？可见他这四条啊，这是出自于《汤液经》。那么张仲景对于这个，啊，“厥阴之为病”，啊，那一个提纲啊，他也不满意。他要满意的话，你像这个，后头这个方剂里头乌梅丸，啊，当归四逆，肯定这是厥阴病，治疗厥阴病，是吧？虽然它治的是厥，但是这个属厥阴。那么张仲景为什么不搁到跟前儿呢？它就与提纲搞不—致来。所以他单独的呀，写…我们方才讲这一章，啊，就是厥、利、呕、哕四个病形脉证并治，这里头他一个意思。那么王叔和给他搞—块儿了，啊。这个咱们讲过了，先不…不—谈了。那

么这个六经，我方才说了，这个规律，这六个病形，啊，就是这个表里，半表半里，啊，这是个疾病反应的病位。（音频 039 完）（音频 040 始）……那么古人管它叫太阳病这个东西成问题了。这六个类型这是客观存在的，是不是与经络有关系？这是古人的看法，啊。这一个呢，这是个…啊，看着就像挺平常个事儿，这很大个事情。一搞到经络上了，那么自然而然的，对于这个疾病的认识啊，就出了问题了。《内经》那一个经络，他根本就是…啊，与他这个所说的，就是不是一致的。他这个书首先他是表里相传，啊，由表传半表半里，由半表半里再传里，或者有表直接传里。所以咱们讲这个太阳病，啊，有太阳阳明并病，有太阳少阳并病，有少阳阳明并病。没有阳明太阳并病的，啊。先见阳明后见太阳，没有。他这个，他是表里相传，《内经》它不是了。《内经》他上说什么呢？它既叫六经，它外经络内脏腑嘛。都有经络，经络都是表。你看看这个东西你就没法说了，是吧？我们读完这个书，读完了你好好看看是不是？不是的。所以这个经络就是不对。你看看他们注家也是的，阳明也有表证，啊；那么太阴也有表证，没有没表证的。我们现有遇到这种表证，你说他是哪儿？他这个错误从哪儿来的呢？就从古人这个认识。他六个类型，他给弄个经络。这是很有关系，很有关系的，啊。那么甚至于咱们搞这个太阳病，啊，这张仲景他也没明白这个地方，他没法子明白。你像这个伤寒恶风，这个关系大了。这个伤寒恶风，啊，这就是，所以咱们就是这个，一般对这个中医的认识啊，就是说有风邪、有寒邪。在哪儿呢？在表。这就对于中医这个发展呐，就起这么一大问题。什么问题？说是这个，有风邪在这儿，是治中风的这个药，都是祛风药。是寒邪在那儿呢，是治太阳伤寒那个药，就叫…啊，散寒的药。他不但把这个病的认识搞错了，连这药物都搞错呀，你可知道。所以咱们现在这个，啊，桂枝是祛风邪吗？咱心脏病也用它嘛！当然不是祛风邪呀。是不是？可是这一个风邪、寒邪之说，这就把这个伤寒给固定了。说

是这个邪是由表来的，就是真正风来这了，寒跑这儿来了。这完了就出温病了。他要没有这个，温病没有的！这个温病你不能说是风邪了、寒邪了。风邪寒邪只是在这儿，这个热就得从嘴往里头跑，这都是一个主观的这么随便设想啊。你好好想一想，这个，所以就由这个中风，啊，伤寒这两个字起的。所以温病他又想出旁的方法儿来了，啊。这是由口鼻吸入的。那也是邪在哪儿呢！所以咱们治这个，啊，治这个温病啊，也是…有…你看那个那个吴鞠通搞的，又有，啊，暑温，又有秋温，又有春温，这…这…这，把这个温还分了多少。这个东西呀，现在，所以中医这么样子搞下来了，整个理论这就是歪曲了。所以这东始终就是不行啊，越搞越…越离开这个，这个事实了，这是不对的。这个温病是不是《伤寒论》讲的，讲了。他开始啊，“发热而渴不恶寒者为温病”，啊，他跟太阳病比较。你像太阳病，他中风伤寒，他都说太阳中风，太阳伤寒，啊。这一个伤寒中风他不说病，那是这么…这个病他这个，与这个太阳…太阳这是单独的这么一种病，啊。他说，提温病呢，他不说是太阳温…啊，这个中温了，或者是发温了，他不说这个，他说温病，这个温病就与太阳病对立的东西呀。“温病发热里渴不恶寒”，这个渴在这个书上全是里热。你像咱们讲太阴病下利不渴者属太阴，渴而下利为热利，他用这个，啊，白头翁汤。这咱们都讲过的东西了。那么他这个温病呢“发热而渴不恶寒”，说明是里热嘛。是什么呢？到阳明病篇他又提了。阳明外证云何？是吧，身热汗自出，不恶寒但恶热。这个温病啊，在太阳篇他提了，在阳明病呢？就是一个阳明的外证。阳明病怎么治呢？不就是白虎汤嘛，啊。那么他在太阳篇里提得也很好。发汗不行，发汗这就要转成风温；下之不行，啊；用火更不行。那么用什么法子呢？只有清热一个办法嘛。那么他没明说，但是他这个书里头全包含了。你像后头这个栀子豉汤啊，啊，你像这个三黄泻心呐、大黄泻心呐，啊，白虎汤、白虎加人参，这无一不是治热的。那么真要是把它掌握好了，

一样儿治温病啊，有什么不能治温病。所以这一个，这个看法的错误，这里头，啊，我说这个伤寒中风这两个字啊，这是万要不得的。可是呢，我们要拿它当个证型，可以的。说太阳病有这么两种证型：一种发热汗出恶风的，啊；一种，啊，发热无汗脉浮紧，这一类的叫做伤寒。就是两个证型，没有这个，啊，风邪寒邪之说。所以这么样子来呀，这个中医这个发展呐，绝不是现在这个地步。这个是重要个事儿，啊。这是我们讲的这个。所以我们读这个书也是一样。有些是很对的，啊，那么在这个规律方面我们要必须要掌握，不然的话，你不会用的。那么那个…对于这个认识，你像对于这么两个类型，他也说给起个叫中风，起个叫伤寒。那古人呐，我们不必给古人打掩护，他是个错认识，他就认为风邪寒邪，这一个根据哪儿来的？就根据伤寒病来的。就是咱们现在说肠伤寒。那古人认为那个伤寒呐，就是伤于寒。他说，你看看那个伤寒例呀，那个书就有，成无己那个本，它头前儿有个伤寒例呀，这是王叔和做的。就是寒戾之气，啊，所以冬伤于寒嘛，啊。要是春发的叫春温。总而言之，还是这个邪呀，啊，这个寒邪在里头呢。这一个东西呀，这根本这是都有问题的。我们现在来研究这个，啊，我们假设要是这个，当然是，这个书这个伤寒不是一个狭义的，是广义的，凡是热病都叫伤寒。那么如果要拿肠伤寒来，来看待它，那你就不能跟西医谤了，人家说是这个，啊，伤寒杆菌，你还说不是。那还是…非得说寒邪不可？所以这个东西，证明这个东西不对就是不对呀，啊。这是我们，啊，对于研究这个书啊，应持的态度。就我认为研究中医的人也应该有这一种正确态度。不能够说是他不对了，还得非说他对。再不就是瞎扯，啊。人家说这个，啊，甚至于五脏，这也不是，那也不是，不知道他说的是什么，啊。脾，脾现在他不是一个消化系统，咱们说这脾是消化系统。咱们说这脾不是那个脾，啊。这就是瞎打掩护，你这个理论老搞不出来。回头了，我们再研究吧。

这个六经究竟其实是什么？啊。那么我们还得从这个八纲说起，啊。这个八纲今天我略略说一说。我们方才我也说了，他首先要认识病位。这个病位这个，所说这个表啊，就是体表这个表，这个表就是，咱们人身上这个躯壳，就是由这个，啊，皮肤，再里头就是肌肉，再里头就是筋骨。就是皮肤、肌肉、筋骨所组成这一个就是体表。它在人的最外头嘛。那么如果疾病反应…集中反应到这一个病位上，就叫做表证。这个里呢？他就指着人的这个极里头。极里头就是这个消化道啊，啊。由这个大小肠胃所组成这个消化道。那么疾病啊，集中反应到这里头，那就叫做里证。那么半表半里呢？就是里之外、表之内，那全是，啊。就是咱们现在最…容易提出来一个抽象的事情，就是胸腹腔间，啊。胸腔腹腔，这么两个大腔子，里头全是。就是我们一切脏腑，除了脑髓而外，都在这里头呢，是吧？这就叫半表半里。他是这个样子。这就先从这个表里，半表半里，我们说这个八纲啊，他其实九个，他半表半里呀，他古人呀，包含到表里里头了。那么另外呢，就是阴阳。这个阴阳啊，在它，咱们说阴证阳证，不是咱们寻常辨证所说那一个阴虚、阳虚那个阴阳，不是的，啊。他注家都给搞那上去了。他说这个阴阳指着性，阴性阳性。那么就个东西，阴性阳性是什么呢？就是一个，啊，太过，一个不及，这么两个方面。那么也就是，人一有了病了。你这个生理机能要有改变的，那是一定的。尤其这个代谢机能首先改变，啊。这个改变这个，机能之改变呐，它只是两个途径：一个就是比 这个健康人太过了；一个就是比健康人不够了、不及了。现在咱们是连证候带脉全是这样子，就是太过、不及。那么太过，他反应这个证候啊？他也相当的要有这一个，啊，发扬的，啊，啊…兴奋的，啊，亢进的这一套反应出来，这古人就叫阳性证；反之呢？他叫沉衰的，啊，抑制的，他不但不发扬它抑制，啊。那么这一类的证候呢，就叫做，啊，阴性证。所以这个，有了疾病了，这个机能上要发生这么两方面的变化。所以这个病啊，千变万化，但

是不外乎阴阳两大类。他不为阴，便为阳。也不为阴也不为阳，这人没病。你这个，啊，这个生理机能蛮好嘛。哪儿没有太过的，哪儿没有不及的，那不就是正好嘛，那就没有病。咱们现在量血压也是一样啊，看你高，看你低，不高不低你血压就没病了嘛。我们人身上的机能，整个他也都，啊，不太过也不不及，就是没病嘛。有了，有了不是太过就是不及，所以不是阴就是阳，就这么两大类。这个阴阳之中啊，还有些特殊的情形他要辨，就是寒热虚实。我今天这么，是略略的说一说。你像这个寒和虚都是不及，也都不及呀，都属于阴之类；热和实，都属于太过呀，也都属于阳之类。就阳之中有些特殊的阳性，在辨证上与治疗有关系的，也要辨。什么呢？一种是热性的；一种是实…实性的。这个实咱们知道，这个人身体直抽抽了，就是虚，啊；反倒亢进，那就是实吧。“虚寒”与这个“热实”它是对待呀。可是这四种啊，都是同属于阴阳的。所以我们在阳证里头，他这个书上也…也有了的，啊。有阳热；阳实；啊，阳实又热，叫做阳实热，啊；也有种阳虚证，阳证这是个虚证，但是他有热，也叫虚热证啊。那么阴证他也是一样的，所以只能有两大类。那么在这个证候上…证情…病情上说，只有阴阳两大类。这里头还得分，我们这个六经啊，就是反应到表、里、半表半里，或阴或阳六类，这就六个类型。在这六个类型里头，你像他还老说：此无…啊，此无阳也，此无热也，他这个书上也常说呀，啊。那么在这一个上，你还得分析寒热虚实。所以我们这个六经啊，只是表里阴阳有了，但是寒热虚实啊，在这个阳性里头，你还要…阳性是一般的，啊，还有一种特性的东西，热与实。那么在阴证里头呢，啊，你还要再辨虚与寒。换言之，我们这个六经里头，这张仲景这个书，他既辨这个六经，同时他也要辨八纲，啊。表里阴阳有了，你再辨寒热虚实，八纲不就都具备了嘛。那么在这个阴阳寒热虚实，这可以说出来一种这个，啊，治疗的法则了，你像咱们太阳病吧，太阳病，啊，当发汗，这就是太阳病的一个治疗的法则了，也

可以叫做治则。那么热呢？热就得用寒药啊；寒？寒就得用热药啊，是吧？虚得补，实得攻。这都是治则。他，他这个六经，以至于寒热虚实，这个治则，这个书里头随便一看就看得出来。可只有治则不能治病啊。你像咱们说这个太阳病，太阳病，那治则一张嘴就知道得发汗。拿什么方剂发汗呢？那还得具体的事实具体分析，还得到方证上。所以他这个辨证啊，在这一个书是这样子，先辨六经。六经他是六个固定的类型了，然后再分析寒热虚实，在这一个时候，这个当大夫要是看病看到这儿呀，心里就有数了，啊，他知道用那一种法则来治疗这个病。应该用什么方药？他还要进一步追，那就辨方证了。就这个书就是讲的这一套东西。那么我们现在要问这么一句话了，那么究其实中医这一套辨证的方法，那么它是怎么个方法啊？治的什么病啊？这一个我们值得研究的。这一个，我想中医呀，搞了这些年，还没人在这上面，啊，来解释出来，这一个是重要的事情。第一个我们就要，根据这一个，啊，八纲不用说，就拿六经说吧。这六个类型，这就是啊，凡有疾病，他这个病位呀，不出于这个表、里、半表半里，这是古人这种结论，啊。这个病位的反应啊，不出于表、里、和半表半里。这个病情呢？不出于阴阳两大类。这个病性啊，不出于这么三阴三阳。这说明什么问题呢？为什么不超出来呢？这个东西究其实是个什么呢？我们就可以看出来这么一个问题。这一个八纲六经，就是万有疾病的一般的规律。一般的，那不是什么特殊的。你像咱们说太阳病，太阳病是什么病啊？什么病也不是，可是什么病都可以有它。它是一般的吧，就是一般的证，他不是什么病，就是一般的证。凡是一个病要有这个证，中医就用这一个方法儿来治疗，没有错误。这个是很说明问题了，是吧？所以中医这个治病的方法啊，这就是咱们说这个辨证论治了，就根据，啊，张仲景这个书，他就是在疾病的一般规律的基础上，中医是这么个精神：在这个疾病啊，它有一般的规律，在这一个基础上，而讲究疾病的一个通治方法，也可以叫大法，

有人，是吧？叫方法。通治一般疾病。这个东西挺妙啊，怎么叫通治啊？你像咱们拿一个方子，这是很…大家都可以，啊，有这个体会，治很多的病；一个病呢，你可不能固定一个方子。你像咱们拿太阳病说，是吧？你无论温疹也好，伤寒也好，啊，这个，以及其它各种疾病，只是要发生太阳病，如果他是桂枝证，你用桂枝汤方，什么病它都治。不但这一个证状消失，他的基本的病也是好的。这咱们在临床上不就这一套嘛。所以中医治病啊，这个主要的精神，就在疾病一般的规律这个基础上，而治一般的疾病，统治一个方法。他就他这个，治病的方法是这一套。这一个你别看，挺妙啊。那西医现在他这个，非常进步了，但是在疾病的一般规律他知道，我看过他们这个病理生理，啊，研究病理生理，他也主张研究这个疾病一般的规律。他解释一般规律解释得还挺好的。尽管发病，原因不同，啊，形式不同，他有一般的规律反应。可是西医这一个他认识，可在这一个上，治疗一般的病啊，他还没有呢。所以中医，这古人这个，啊，通过这个临床，啊，这一种实践，他搞这一套东西，非常成功。所以中…这一个很重要。所以中医你要是搞科研，你拿一个病名儿来固定用一个方子，根本就不成立。中医不是啊，他在一般的规律上，治一般的病。你像咱们用那个柴胡汤，啊，你只是现柴胡汤证，我就用小柴胡汤，是没问题的。不现，不现用它有害无益。中医是这一套东西。可是这又说回来了，在一般的规律上怎么能治一般的疾病呢？我们再追究一个，中医有一句话最好，就是“正邪交争”啊，张仲景这个书就是的，《内经》上也是的，啊。中医认为人这个…人体呀，对于疾病啊，它绝不等着它病的，老与它斗争，老是正邪交争啊，事实也的确这样子。人体要是没有这么一套的这个良能啊，那得传染病非死不可，是吧？它就因为对…对这外界的刺激它非常有一种这个抗御的方法，你看咱们要是有一种这个传染病，他不是人人传染的，顶厉害的传染病了，死的人还是少数，是吧？他那个没感染的人，他不是他没接触过，他这

个身体的抵抗力强，抵抗力是什么？就是我们身体对于这个外来的东西它能够有抵制，那就是“正邪交争”。那么有了病了它还跟它交争。你像咱们讲那个表证，这个太阳病你好好分析，它就是正与邪交争在体表。怎么个交争法儿呢？就打算出汗。这个《内经》说的，你们看看 那个什么，那个，那个…“阴阳交”那一段，挺好说的，啊，“今邪气交争于骨肉”，啊，我记得我讲的时候引证这一段了。他就想在体表以发汗的这种办法把疾病自体表排除。那么这个里证呢？它就想由里把它排除，或者吐或者下。这个半表半里呢？就想借这个半表半里各种脏器的功能，而把它排除，呼吸系呀，泌尿系…泌尿系呀，啊，等等的吧。那么这一个就限于人的这个自然的结构啊，啊。对于这个疾病的这个斗争这个方式啊，也只有这么几种，他限于自然的么。这个人体万人相同。所以这个正与邪斗争啊，离在不开这几个方位，所以就固定了一定的病位。所以这病位哪来的呢？主要的还是咱们这个，啊，“正邪交争”，啊。这个机体的本身还是个主导地位呀。他打算从这一方面解除疾病，或者从那一方面…除此而外没有了，他限于这个生理呢，生理这个…这个自然结构啊。可这就把病位给固定了。病位一固定了，如果机能亢奋他就阳性证；机能沉衰它就出来个阴性证。这个六经，啊，这六个类型…是…只要是疾病存在，这个机体就斗争。就斗争它就不出这个范围。所以我们在一个疾病全过程里头，这一种六经八纲的反应始终不会…不会离去的，而且始终也不会超出这个方位。我们再拿这个治则，根据这一个…我方才讲这一个，啊，六经八纲这个生成的这个…这个来历，我们还可以理解一个问题。就是中医这一套辨证施治啊，正是适应人体的这个机制，啊，抗病的机制，而使他达到目的。你像拿这个表证吧，他欲发汗，发不出去汗，所以“脉浮头项强痛而恶寒”，这一种表面这个，充斥体液的这个情形啊，都显出来了。哎，中医呀，他古人他就是，他试验的结论嘛，在这儿你发汗就好了。可是这个发汗呢，正达到这个机体的

这个机理要求。所以中医这个东西还是原因疗法，啊。那么我们又说了，你像这个，那么他出汗了病还不好，怎么个事儿呢？这就像拿这个中风证就是这样子。他本来他自汗出，那么达到汗出了，病还不好。这个《内经》上也有啊。他说这一个，啊，“汗出而邪留”，这就是我们这个机能啊，力量达不到。不是他不得汗出，啊。你像我们说那个太阳伤寒，他机能达到了，他就是出不来汗，啊，你一开其腠理，让他出点汗，嗯，它邪出去就好了。这个中风证虽然出汗了，但是他就是精气虚嘛，这拿《内经》上的话，就精气虚呀，这他这个书上也是啊。什么叫精气呀？那古人要，这个人体要想出汗，他就是用谷气，啊。这谷气古人叫做精气。精是精真养人之气了。虽然出汗了，由于精气这个质和量它不足以祛邪，反倒出毛病了，汗是往外跑了，邪还是趁虚而往里头来了……（音频缺如）……我们在后世方也可以，就兴这么两大系列的不同方剂。一种就是以桂枝汤为主的加减；一种是以麻黄为主的一种加减。形成这么两套，你像…啊，桂枝加桂呀、桂枝加芍药啊、桂枝去芍药啊、桂枝去芍药，啊，加龙骨牡蛎等等的，这都由桂枝汤的这个证候出入他加减，有这么一系列的方剂。以麻黄汤为主呢？更是了，啊。麻黄汤、葛根汤、大青龙汤、小青龙汤，啊，以至于麻黄桂枝各半那都属于麻黄剂了，他是为发汗的嘛。那么这就形成这么两大系列的方剂，除之而外都不是。不是他搁到太阳篇里干什么呢？他就为了应急之便呐。张仲景这个书啊，这个太阳篇是最说得最多。他这个病它不是固定的，不是太阳病老是那么一个太阳病，它随时的，啊，由于治疗的关系，兴许误治，由于这个病转…传变的关系，那你研究太阳病，这个地方他都要说呀。而且为了发汗，有些可发汗的，有些不可发汗的。你像我们这个阳明病它也是…他每一章头前儿他都是，反复的这么说。所以这一个，我们在…啊，那么这是…今天就说一下概要吧。再有呢，就是这个辨六经。我们方才说了，这个半表半里病啊，它不像表里单纯呐。你看那个表证，啊，无论太阳

病、少阴病，都好辨。那么里证呢？无论阳明病、太阴病，也好辨。都在肠胃里头，啊，这个是体表啊，身疼痛这一套，这一套东西他是好辨。最复杂的就是半表半里。你像我们说那一个“口苦，咽干，目眩”，白虎汤证也口苦咽干呐，也有目眩呐。他里头有热，它循着孔窍往上来，他就有这一套东西。所以也不够。那个厥阴篇更成问题了，那么是不是古人他在这里头，他一点也没认识？不是的，没法认识。你像我们方才说那一个，这一个，这个半表半里这个部位呀，它牵连到一切脏腑。你看那小柴胡汤就看出来了，或这个，或那个，它这一个不好用简单的把它概括了，没法儿概括也。所以这个少阳病的提纲和这个厥阴病提纲都不够全面。这儿只能做个参考。那么怎么辨呢？这成问题了吧。有办法。他这个书上啊，啊，也举这些例子。你比方吧，即表证好…好辨，里证好辨，除去表里呢，那不都是半表半里嘛！所以我们在临床上，也是天天儿用这个法子啊。就是不是用发汗的方法治疗这个病，也不是用温补或者是吐下的这一种的病，这就是表里都没了。剩下那个呢，都是半表半里病。这个半表半里，要是反应的是阳性的，那就少阳病；反应阴性的那就是厥阴病。就这就够了。所以这一个半表半里这一个，你看看那个厥阴病他只是四条，他也没详细说，没法儿说。那么这一个少阳病呢？也是，就是口苦咽干，啊。他就在柴胡证里他说得清楚，他这个事实不可能。这一个地方啊，他牵连到这么些的脏腑，啊，这一个地方要有…这个…假设这个，这个地方要有一种，无论是…啊…有这种这个，啊，有病，它最容易涉及到其它的脏器。所以，你像那个…用些或或的这个也不行，啊，那也不够个提纲，啊。或者那么的，或者那么的，那还都是不行。所以没有法子。我们只能够在临床上啊，啊，第一个，这个表里好辨呐，你像咱们说感冒这一套东西都是太阳病，如果人虚衰，脉微细，这都属于少阴病，啊；那么这个胃家实这一套，啊，不大便，啊，大便不出来，所以他是只热，就像白虎汤证，这都是属于阳明病啊；腹痛下利，

啊，虚寒在里这一套东西，都属于太阴病。那么这个表里好辨，除去表里都是半表半里。所以这个辨证啊，啊，啊…也并不难的。只是…他这个书啊，主要的他是以六经他分篇，他就是这个。可是在这个少阳里头，在这个这个厥阴里头都不够的，啊，这个我们要，也要知道。但是呢，这一个，我搞这么些年，我也曾经积累一些经验，对于少阳病，的确这个变化是相当的多，也拿不出来一个更好的一个，啊，一个特征。那么只是怎么的？只是，啊，先辨表里。这个东西常见了，用不着特意辨。来了病号了，一看就知道，啊。他一说你就清楚了，他表里很容易嘛，离开这个他都是半表半里。在半表半里这个方剂上也相当的多，啊。今天咱们就是聊聊，这瞎聊啊，略略就是。

李冠杰：一些真正关于六经实质的问题，其实从太阳篇开始我们一直就在讨论，这个不是本次讨论的重点。本次讨论的重点是假如经方理论的六病辨证不是历代学者总结的是由经络发病或是脏腑发病而来的，其跟《内经》理论不是一个体系，在中医理论中这是一个特殊的论述方式的问题。在这个问题上，历代的学者都没做过实质性的探索，因为他们都认为《伤寒论》是在《内经》理论指导下的一本关于方剂的专著，是一本方书。但是现在看，到底历史过程和当时大致的背景应该是什么样子？我们今天站在还原经方理论本来面目的角度上，再去重新审视一下，因此这里论述的所有观点，在以前各个注家的著作和相关论述中都是没有的。

关于经方理论中以三阴三阳划分六类疾病的认识，历代学者始终存在着不同的理解，直到两千年后的今天仍然没有统一。这对于一个经典医学理论来说是很遗憾的，经方医学之所以出现这种特殊的现象，根本原因最早要上溯到王叔和。对经方医学的注家和继承的后人来说，我们一直往下推到此时此刻，诸多的注家都是以经方理论之外的理论体系来解释经方医学，从我们解读《康平本伤寒论》就能清楚地看出凡是用这样方法的，都是张冠李戴，不得要领。

事实上解释经方理论恰当的正是经方理论本身，而不是经方理论之外的其他医学理论。作为中医理论之一的经方医学，毕竟是祖国医学的一部分，如果说它与现代医学（西医）存在着本质的区别这不难理解，每个人都能接受，但要说它与其他中医理论（传统中医）也有本质的区别，甚至一定要将其视为一个独立的医学体系时，似乎就让人感到比较费解。但是，我们对经方医学发展的历史进行客观、实事求是的分析后，就会发现其中确有令人深思之处。

经方理论有个非常显著的特点就是方证相应。在经方理论中重病证，而不重病位和病因，这在所有的医学中都是独树一帜的。经方医学这种对证治疗的模式和理论，初看似乎只是保持了一些人类医学最原始的状态。现在在一些电视节目里也能看到，发现很多动物就有用身边天然的物质治疗自己疾病的一种本能或者经验，所以实际上人类医学也是从这类基础上发展起来的，逐渐地积累、实验。最初时肯定就是某药治疗某症，对疾病有个由浅入深认识的过程，刚开始肯定就是对症状。经方理论也是对着症状用药，所以说其还保持在人类医学最初级的阶段，这是给人的一种粗略、直观的印象。

看经方的书也是这样，若是对经方不了解的人初看《伤寒论》和《金匱要略》时，就特别感觉像在读一本在症状和方剂之间划了等号的小册子。纵观人类医学，无论是东方医学还是西方医学，实际上都经历了一个由经验到科学、由感性认识到理性认识的过程。直到今天由于这两大医学对现代科学技术依赖的程度不同，造成了中西医（这里的中医指的是经方医学以外的传统中医）之间无论是理论上还是实践上都存在着本质的差异，但站在宏观角度分析，这两种医学基本的思维方式是一样的。其相同点都是通过疾病的现象进一步向疾病具体的病变部位和病变性质的方向进行深入研究和探索。实际上经方理论也是向疾病的本质探索，但是方向不一样，传统中医和西医都是通过症状去找到底在哪个地方、哪个脏腑器官发生了什么性质的病变，但

经方医学不是。经方以外这些医学的目的是要用这种探索来进一步探明疾病的本质，并且在探索过程中形成了各自完整的医学体系。传统中医有自己完整的医学体系，西医更有自己完整的体系，它们之间所不同的是西方医学更依赖于现代科学技术手段，所以也被称做现代医学；而传统中医由于发展成熟比较早，当时没有如此强大的科学技术可利用，所以更多地依赖于传统的哲学思想和理论推演。但究其本质而言，这两种医学没有质的区别。试想一下，假如以《内经》为代表的传统中医理论在形成的那个时代，人类就已经有了现在这样发达的科学技术，那这些研究内容与今天现代医学研究的内容就不会有多少质的区别了，从《内经》对人体结构的研究，对具体组织部位和脏腑器官作用的研究，对具体病变性质的研究，以及外界因素对人体疾病之间相互关系的研究，都能清楚地看出这一点。只是当时没有显微镜，没有化验手段，没有现代技术，要是有的话也是往这个方向发展的，也是要认识这些东西的。

但是经方医学恰恰是在思维方式和研究方向上，跟这些医学存在本质的不同。纵观整个经方医学理论，特别是通过对《康平本伤寒论》的深度解读，可以清楚的发现在经方理论中（特别是顶格条文），几乎没有一处是对某个具体的脏腑器官发生的某种具体的病变进行研究和论述的，所有的病理研究和疾病治疗都是围绕着人体患病后所表现出来的症状反应进行的。说到这儿有人可能会有别的想法，《金匱要略》里就有肺痿、肠痈，这不都是具体的部位么？其实仔细去看这些杂病部分（后面还会讨论为什么弄了一部分杂病）具体的论述，只是用了当时比较流行的以脏腑器官命名疾病的说法而已，只是用了一些名字，实质性的论述仍然是遵循方证相应的原则，条文里真正论述的都是症状，都是方剂的适应证。这就好像是经方医学是有意保持人类医学的原始状态，就是不进步，就停留在这种状态下，其他医学认为哪一类症状是肝脏或肾脏得病了，经方医学就是不去认识那一块

儿，就认为什么样的症状就应该用什么药来治，貌似是这样，其实不然。现在可以说，经方医学排斥了以《内经》为代表的当时人类对疾病研究方面取得的最高成就、最新成果。

从另一个角度看，临床实践在几千年的历史进程中无数次证明经方医学应用于临床，即使在现代医学高度发达的今天，其疗效依然是其他任何医学没法比拟的。这就形成了与人类常识相矛盾的一个悖论，就是“落后”的东西反而成了最好的，当然这个“落后”是要加引号的。所以要解答这个问题，尽管现在对早期的医学知道得不多，但还得从人类医学的发展过程中把它弄清。人类医学和其他科学一样，经历了一个从低级到高级，从感性到理性，从浅显到深入的发展过程，作为人类医学一部分的经方医学，实际上一刻都没离开这种发展变化的环境。所不同的是，经方医学似乎一直沿用了最原始的理论与方法，却达到了其他处于不断发展进步中的医学所达不到的高度。这个高度就是临床中的高治愈率和可重复性，这就提示我们不能不对其中的原因做认真地研究和分析，并从中找出规律性的东西。现在等于是揭开了冰山一角，因为这种看问题和分析问题的角度，以前从来没有过。

中国历史上的东汉时期是经方医学趋于成熟的年代，距今已将近两千年了。但是从《康平本》中顶格条文的内容和皇甫谧所论述的张仲景“论广汤液”的记载，可以知道经方医学形成的时间还要早一些，应该是汉朝之前的事儿，根据史料看最早可追溯到商初的伊尹（伊尹汤液经），到目前为止仅知道这些。尽管如此，在中国当时的医学理论中经方理论并不是唯一的，甚至在当时乃至之后整个中医历史上，经方医学一直都称不上主流医学，这一点从《黄帝内经》中就可以得到佐证。《黄帝内经》不单在成书时间上要早于《伤寒论》五百多年，而且其理论体系的完整性和全面性，以及其理论的形成和成书的社会背景都是比较高的。《黄帝内经》里是黄帝和大臣的对话，当然这肯

定不是黄帝写的，但那时不允许拿皇帝随便开玩笑，所以说明其成书的背景、社会的层面非常高。这本书在社会上的传播范围以及对中医理论的影响都明显比经方医学的层次高很多，影响也大很多。

实际上《黄帝内经》才是真正主流中医发展的代表之作，而且至今还被奉为“中医四大经典”之首。经方医学理论在从形成发展到成熟的历史过程中始终是和以《内经》理论为代表的传统中医（下文称主流中医）的理论并行发展的，有《内经》理论的时期其实也有了经方理论。这里就有一个我们必须面对、不能忽视和回避的问题，既然在经方理论成熟之前就已经有了《内经》这样既包括了医学理论又涵盖了哲学、社会学以及当时自然科学在内的一部巨著，其对人体的生理结构、脏腑功能、病变规律和致病因素等方面的问题研究得面面俱到，在当时堪称最为先进的医学理论，那为什么纯粹以治疗疾病为核心的经方理论却对《内经》的相关知识极少引用和论述？特别是把《康平本伤寒论》中降一字格排版的和降二字格排版的条文都剔除出去，只剩顶格条文，其所有的论述跟《内经》毫无关系。这还只是从字面上看，另外从论述的内容上看，比如疾病发展变化的规律与《内经》理论也是不相通的。这就提示我们不得不思考另一个问题，难道经方理论的创建者对当时的主流医学理论一无所知吗？答案肯定是否定的。那到底为什么会出现这样一种局面？为什么视最先进最有主导资格的医学理论而不见呢？对于这个问题我们没有实实在在的历史资料支持，只能做逻辑上的推演，要从不同的角度来分析。

我们换个角度来看，现代医学以科学严谨见长，几乎所有的理论都建筑在科学实验的基础上，这是众所周知的事实，作为现代的中医学者对这个问题自然也都非常明白。但为什么中医仍然坚守着几千年前形成的医学理论核心，而不为现代医学的科学成就所动？回答这个问题就非常简单了，作为中医人都能说出一些门道来。现代医学在很多方面和具体问题上根本无法解释中医理论中的一些常识性的东西。

而相应的在现代医学中被认为的不治之症或治愈率很低的疑难病，在中医看却常常不是那个样子，不仅是可治的，经常疗效卓著。当然不是整体都这样，要根据医疗水平的高低，中医医疗水平高的治一些疑难病是很有效的，不用说别的，每一个经方继承者都有这样的感觉。再看看胡老的医案，他治的很多疾病都是屡经西医甚至中医治疗不好的病。西医治病比较简单，常是除了需要用的仪器这类东西有差别以外，其他的大医院跟小医院差不了多少，治疗方案几乎都是一样的，但中医就不同，不同水平的医生最终治疗结果是不一样的。整体来看，现代医学里的最新成就、最高明的医生认为没法治疗的一些疾病，在中医里一些比较有水平的医生轻而易举地就可以治好。事实上中医的很多常识性的理论和认识，在现代医学理论中无法认识到，比如中药，它们和人体不一样，人体非常复杂，西医认识不到的东西很多，中药却非常简单，都是一些死物件，现代医学虽然拥有最先进的科学技术，但到目前为止没有对任何一味中药的治病机理有实质性的认识。无论怎样研究，怎么有消炎作用、化学成分、结构等都是片面的，与实际临床应用接不了轨，无法解释它们在方剂中的作用。这也就是为什么在现代医学如此发达的今天，中医依然保持顽强生命力的原因所在。

我们弄清了这一点，再来看看经方医学和以《黄帝内经》为理论代表的传统医学之间的关系。经方医学的实质与传统医学和现代医学之间有着惊人的相似之处，这是我的个人观点，这样讲是有根有据的，不对的可以讨论。经方医学方证相应的理论核心，表面上看有着浓厚的原始医学色彩，而以《内经》理论为代表的传统医学在当时无疑是最先进前沿医学的代表和象征。那经方医学的创建者为什么不接受当时最先进的医学理论，反而在原始医学的基础上又建立了一套在当时看来也比较另类的医学体系。大家可以看看《内经》再去看看《伤寒论》，特别是《康平本》的顶格条文确实比较另类，也显得比较土气，几乎没什么道理可言，就是一边是方子一边是症状。这实际上与今天

的中医理论和现代医学理论之间的关系如出一辙。事实上，经方理论的传承者并非不了解传统医学在当时取得的成果，今天从逻辑角度讲，作为一个医学理论的创建者对相关的理论知识，特别是新的理论知识必然会在一定程度上有了解和接受的过程。这就像现在很多中医人也常用西医的理论来解释中医的东西，甚至二栖的医者也有很多。根据这种现象我们可以推测在历史上经方的传承者也是这样，真正接受了传统医学理论的那部分人慢慢就成了传统医学的传承者和实践者，但另一部分传承者中有一些治学态度极其严谨的人在经过了长时间的临床实验和理论总结后，发现当时最先进的医学理论反而在诸多方面与临床实践无法接轨，虽然理论看似周密深邃，但应用于临床却不及原始医学的实际效果。另外反过来讲，传统医学理论的进步和发展也必然会对经方医学理论的继承和发展产生一定的促进作用，并使其最终形成了一整套以方证相应为基础与核心的医学体系。由于没有史料支撑，因此上述观点基本都是推论。《黄帝内经》和《伤寒杂病论》是我们今天所能见到的最早的医学专著，所以在这两种医学成熟之前的史料已无从考证了，就只能借助于考古人员的思维方式对现在能看到的这两本书做深入地分析和合乎逻辑地推理，同时通过对经方理论研究成果的分析和对经方的现代研究，也能支持上述结论。

经方临床应用的大量统计资料显示，每一个经方方剂都与其适应证存在着稳定的对应关系，尽管该方证本身是一个动态的范畴。方剂和方剂适应证之间的对应关系是铁定不变的，尽管适应证不是特别稳定，但方剂和方证与疾病之间的关系是没法比的，跟具体的疾病，特别是发生病变的某个脏腑器官和具体的部位组织始终没有稳定的对应关系。比如小柴胡汤证，凡见四大主证都可用小柴胡汤取得良好的疗效。就是说在这种症状反应的病理环境下表现为小柴胡汤证的患者，无论是心脏方面的病、肝脏方面的病、脾脏方面的病、胆囊方面的病、肺脏方面的病、肾脏方面的病、胰腺方面的病、胃、肠、五官、

妇科、儿科等病变部位，还是其他任何的病变性质，都可用小柴胡汤来治疗，而且疗效特别好。这就说明了一个非常实在的问题，就是这类以具体的病变部位和病变性质研究疾病的医学，只是用了一种片面的方式，得到了一个片面的结果，只有经方医学的结果才能得到临床实践的支持。临床统计资料就是彻头彻尾的、百分之百的临床实践，我们今天借助临床统计资料来证明上述这些规律，那当时的古人、经方的实验者、实践者和继承者也是通过长时间大量的临床实践总结得出了同样的结论。假如得不出这样的结论，就不会坚持这一套理论，就必定会倒向《内经》阵营里去。因此经方医学没有接纳传统医学的最新研究成果，看似还是保持了原始医学的外貌，其实当时的人已经掌握了必须和临床实践接轨这个真正的规律所在，这也是其能够传承至今的关键。

下面以具体的医学实例来分析。现代医学最新研究孕妇在怀孕三个月左右时是胎儿大脑发育的关键期，孕妇需要大量的 α 亚麻酸。这种物质人体自身不能合成，只能从食物中摄取，常见的食物中核桃含此类物质的量最高。通过所谓的科学实验和计算，证明人体要满足正常胎儿对此类物质的需求，一个孕妇每天必须吃 17 斤核桃。这种所谓的最新研究成果，无论如何也没法让真正的中医人信服。自有人类至今没有一天中断过新生儿诞生，同时也没有任何一个孕妇能在一天内吃下 17 斤核桃，更重要的是没有任何证据能证明因为母亲没有吃够 17 斤核桃孩子智商有任何的下降。所以这种理论不单是无法让中医人认可，实际真正有主见的普通人也无法接受，只要动脑子的人都知道这种理论是站不住脚的。

我们再来看看作为传统中医精髓和指导方向的阴阳五行理论。为什么经方理论没有把传统医学的五行理论借鉴过来，而且是用了一种拒人千里之外的态度，问题就在这里。虽然阴阳五行理论与现代医学的某个组织发生某某炎症之类的疾病概念相比较，能将人体看做是一

个有机的整体而不是一个独立的器官组织，明显地五行理论多了整体观的理念，但是具体的人体脏腑之间是不是真正按照五行生克的规律发展变化？这点得不到临床实践的支持，甚至纯理论的推演也常常不能自圆其说。实际上学中医没有不学阴阳五行的，我当初也是学这个过来的，而且当时对五行的理解比现在某些专家理解还深，比他们解释得高明。但后来仔细再去推就推不通了，自己都不能自圆其说。所以这一类的理论跟上述孕妇吃 17 斤核桃的西医理论是一样的，那个理论放在中医人眼里是无法接受的，那阴阳五行理论放在当时的经方家眼里同样也是无法接受的，这就是在经方理论中丝毫看不到《内经》理论的原因所在。

在临床应用上也存在同样性质的问题。传统医学和现代医学都沿用了一种从症状到具体病变部位和具体病变性质来认识和界定疾病的模式。然后在这个基础上，寻求针对病变或病因进行治疗的一些方法。传统中医和现代医学不同的是，前者因为当时没有发达的技术手段，所以对微观上的病因了解非常少，由此便在临床实践的基础上，发展出了一套治疗具体脏腑器官的寒、热、虚、实、阴、阳为主要的辨证方向的方法，而后者则更多关注的是外界的致病因子，所以治疗上也多是以对抗病因为主要手段。而只有经方医学才能还原疾病的本来面目。这里需要说明一点，不是其他医学不能治病，不是要把经方医学和其他医学对立起来，但是高低层次不同。胡老是真正的经方实践者和继承者，所以才会在医案中出现大量屡经中西医治疗不好的病，到了胡老手里很简单地用经方就治好了。经方医学坚守临床实践为核心，在方证相应的基础上发展成一套从症状反应到整体病理状态，再到具体方证的辨证施治体系。在临床实践中，只有这套病理辨证体系才是真正与临床实际完全接轨的医学体系。

下面以具体的疾病为例子来阐明。比如有个以往来寒热、胸胁苦满为主要症状反应的患者，采用经方理论来辨证，就是处于一种半表

半里虚热证状态，并且兼有一点里虚证，具体就是小柴胡汤证。无论这时患者发生何种部位、何种性质的疾病，都可以用小柴胡汤治愈，并且疗效极佳。而同样是这个患者，采用传统中医理论或现代医学理论辨证，所得出来的却是另一种结果。因为这些医学理论都先要通过症状反应去寻找具体的病变部位和病变性质，比如传统中医碰到一个肝胆病人，最终结果可能辨证为肝火，叫相火炽盛属于肝胆类疾病，就要用入肝胆经的寒性药物治疗。实际临床中有一些医者可能在这种情况下能用到小柴胡汤，并且起到速效，他就会觉得自己的这套医学理论挺好，但在经方医者看来，这是一种偶然现象。因为假如再碰到一个有类似症状的肾病患者，就可能辨证成肾阴虚、肾炎等情况，就绝没有再使用小柴胡汤的可能了，理由是他就认为小柴胡汤是清胆热的，是治肝胆病的。那对这样的患者不用小柴胡汤，最后的疗效就可想而知了，当然不一定是治不了，但疗效会很差或者无效。从这一点上看，小柴胡汤证完全可能出现心脏方面、肺脏方面、肠胃方面、胰腺方面的疾病，所以传统中医用到小柴胡汤治的反倒是偶然现象，这也是其疗效不好的原因。另外再说现代医学，它是通过症状反应进一步找到是什么样的致病因素造成的，具体就是什么器官发生了什么性质的病变，或肝炎，或胆囊炎，或肺炎，或肾炎等等，然后再用对抗或杀灭致病因子的药物进行治疗。比如临床中经常遇到十年八年胆囊炎的患者，经过无数次西医治疗也没治好，患者都没有信心了，有的发展成了胆结石，最后做手术把胆囊切掉了。可是放到咱们经方人的手里，看着这种现象就痛心。

通过这个实例大家再想想，不同的医学体系在实际临床中的差异，正是由于不同的思维方式和研究方向所造成的，相比之下谁高谁低就一目了然了。

在弄清了上面这些问题的基础上，我们再来重新审视一下经方理论中的疾病。关于疾病的概念，经方以外的其他医学都是以病位、病

性和病因等因素作为界定的依据，而经方医学对于疾病就是以症状、病理和方证来界定的。

下面说个具体的证——下利。现代医学把这一类的症认为是消化道内发生的不同的病变，以此为鉴别疾病的依据，比如说是菌痢、肠炎等，然后再按着相应的方法治疗。而传统医学则是以脾胃的寒热虚实作为界定具体病变的依据。但经方理论在界定的时候，依据的是不同的病理与方证。大家看，下利既有里虚寒性的理中汤证、四逆汤证、通脉四逆汤证和通脉四逆加猪胆汁汤方证等等；也有热性的葛根芩连汤证、白头翁汤证和大小承气汤证等等。这些方证虽然阴阳、寒热、虚实等疾病性质不同，但似乎还都属于消化道内的病变，貌似跟其他医学只是说法不一样而已，但要仔细推敲，还有一些以表证为主要病理矛盾的下利，例如在葛根汤证和桂枝汤证中都有可能出现下利的症状，那对于这一类用解表剂治疗下利的情况，其他医学是根本无法解释的。

更重要的是上述这些治疗下利的方剂，在经方医学中没有一个是专门治疗下利的。就连白头翁汤表面看似是个治疗下利的专方，但实际它还能治没有下利的其他一些疾病，比如眼睛方面的一些疾病。所以凡是符合这些方子的病理状态，以这种方证形式表现出来的其他任何方面的疾病，不论下利与否都能治。这就能明显地看出经方医学和其他医学（传统中医、现代医学）在疾病的概念上完全不同。

因为经方对疾病的概念和其他医学的概念不能接轨，而所有人认识疾病的概念都是通过其他医学的概念为基础延伸出来的，所以没有人会认为一个方证也可以当作一个疾病，实际上经方医学关于疾病的概念就是方证，方证就是基础疾病。

由此可见，在经方理论中所谓的疾病就是方剂的适应证。方剂的适应证又是由一组特定的、动态的症状群组成。所以经方医学实际上就是通过人体患病后所表现出的症状反应，来寻求一种通治治疗方法

的医学。为什么是通治？因为只要表现为这个方证，不管是什么病，用这个方子都可以治疗，所以说是在症状反应的基础上，寻求一种通治的治疗方法。

无论是《伤寒论》还是《金匱要略》，也无论是六经病还是杂病，实质上都是围绕着如何将经方医学理论体系阐述清楚的目的，只是采用的方法和方式不同而已。本质上没有区别，只是叫法不一样，在六经病中叫太阳病，在杂病里就有可能是痉病。叫痉病的原因是在当时已经出现了抽的情况，大家都把它叫做痉病，所以就是用痉病的方式把一部分太阳病论述出来，容易跟临床结合在一块儿。这就是杂病出现的原因，但六经病和杂病的理论基础和核心都是方证，方证相应。

六经划分的实质是什么？六经的划分无非就是将这些最常见、最能阐明经方理论疾病发展变化规律的，同时又具有代表性的一些典型的方证，科学地划分为六种不同类型的疾病。其目的就是要借助于这种在当时学术界最为常见、也最易于被人理解和接受的三阴三阳的分类方法，来阐明经方医学理论。从《黄帝内经》中以三阴三阳来对人体经络进行分类和经方理论以三阴三阳对不同类型的疾病进行分类来看，当时这种方法应该是最先进、最流行和最通用的方法。

值得注意的是，经方理论的创建者没有将所有的疾病都概括在这六类中的意图，如果有，那就不会再有杂病部分的内容了，完全可以把杂病部分都拆开，按疾病性质都归到六经里就行了，但实际并没那么做。而杂病部分就是将经方方证用当时最为流行的疾病的称谓、以疾病分类的方式进行了论述，更易于读者理解和掌握，这就是《金匱要略》的论述方式。

今天看经方理论用这种比较特殊的论述方式来阐明一个医学理论，会令人非常费解。究其原因有个很重要的因素，在当时的历史条件下，经方理论的创建者面临一个很重要的选择就是一定要用最少的文字来论述尽可能多的问题，因此经方理论就是在这种特殊的情况下

形成的。

上面这些分析是一个方向性、基础性的探索。下面再来看看经方理论中的六经病分篇，我们的理解就跟历代注家有所不同。

经方理论中的太阳病历代注家都把它说得与提纲条文的论述越来越远。实际上太阳病就是提纲条文的“脉浮，头项强痛而恶寒”，以这样的症状反应为典型的一类浅表性疾病。这一类疾病的病变部位多发生在体表组织，但不是所有的病变部位都发生在体表，所以只能把这种现象称之为与体表组织的关系比较密切。更为重要的是这类疾病与其他类型的疾病（半表半里证或里证）相比较的话，更具有浅表性疾病的特征。这点在学习过程中，大家都明白。为什么很多条文都冠以“伤寒”或“太阳病”？因为很多疾病都是从表证发展而来的。之所以称作表证，是因为其最具浅表性疾病的特征，这才是称之为表证最主要的原因，其他五类疾病都有这样的性质。

太阳病，就是指表证中的阳性证，也就是浅表性疾病中的阳性证。代表方证是桂枝汤证和麻黄汤证。按照经方理论的分类方法，阳性证就是人体在患病后表现出一种整体机能偏于亢奋（与偏于沉衰相较而言）的情况下出现的浅表性疾病，这就是太阳病。

少阳病，就是半表半里的阳性证。因为其症状反应非常复杂，所以在经方理论中只总结了同类方证中都有可能出现，并且在具体的方证条文中省略而又没有论述的三个症状“口苦、咽干、目眩”，来作为这类疾病的提纲。

在其后的其他疾病类型中也有上述类似的总结。也就是说，提纲条文所作的述症和具体方证有的处于一种交错状态，（提纲）条文里没有的就再说明一下，（提纲）条文里有的就不论了。另外一种情况是有的条文干脆就论的是类似病理，因为太不好总结了，当时是非常务实的。

阳明病，指的是主要症状反应比表证和半表半里证更具有深重

（又深又重）特征的一类方证。典型的方证有承气类汤证和白虎类汤证。

以上三种是人体患病后在机能处于亢奋情况的病理状态下，表现出的三类疾病。而在经方理论中把人体患病后在机能偏于沉衰的情况下出现的三类疾病，界定为三阴病。

少阴病，以“脉微细，但欲寐”为典型症状反应的阴性浅表性疾病。代表方证有桂枝加附子汤证，麻黄附子甘草汤证。

太阴病，以“腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛”这类症状为典型症状反应的一类疾病，较为深重的、有这一类特征的方证类型。代表方证有四逆汤证，通脉四逆汤证等。

厥阴病，以乌梅丸证为典型代表的阴性半表半里证。

以上讲的就是经方六病辨证中的六病，也就是被后世历代称之为六经的。六经并非是后人说的太阳病是太阳经络得病，太阳经络是从哪到哪是人体循行最长的路线等等，这些都不对。六经就是书上讲的这些症状，就是提纲条文和典型方证条文论述的这些内容。这正是一开始给大家讲的，解释经方理论最好的就是经方理论本身，用不着到别的地方找依据，书里都有。事实上经方理论的创建者也非常清楚，对于经方中典型的方证类型以三阴三阳进行分类的方法，并不能十分恰当地概括所有的经方方证，所以就另将半数以上的方证以杂病的形式加以论述。这本身就是个很好的说明，六经不能钤百病，本来就没想概括所有的。所以今天仍然延续这种思路，想把所有的方证都塞到六经里是塞不进去的。

六经分类的意义在于使经方理论的论述变的清晰、简洁、有条理。即使在今天普遍使用电脑，可以完全忽略笔墨因素的情况下，古人总结的这种六病分类方法，在经方理论的阐述上仍有不容忽视的实际价值。

这么讲是有原因的，我把所有方证的病理属性整理完以后，分成

了表证、里证、半表半里证、水证、血证、气证这六大类。实际在这六大类中还可以再分，比如表证，表证与水证一类的方证，像小青龙汤；表证里又可分阴性证和阳性证；表证还有和里证同病的。再进一步地分由于要和大家一起学习，我就没有时间了，后来让同学试着做，但就没有下文了。这个分起来确实比较麻烦，另外分到最后越分感觉越乱，这还仅是把一种方剂剥开，要是写成书呢？我曾经有个想法，以这个为纲整理一本经方实用手册，但是谈何容易。这种乱不是没有头绪的乱，而是面临一个问题，就是一个方剂在好几个地方都要重复出现，还要把它说清楚，不能让人看了以后一头雾水、找不到头绪。所以此时再来审视古人总结的这六类疾病确实很高明，说明六病辨证这种分类方法高度地概括了经方病理辨证体系中最主要的病理元素，符合疾病发展的客观规律。在论述六病的过程中（用六病的方式），已经将经方理论的生理、病理、医理和疾病发展变化的规律、辨证方法、治疗原则、治疗禁忌等，以及其主要的理论要点，用既简明扼要又明确无误的语言做了阐述。

经方理论在论述的过程中，其主要形式是把论述的重点放在方证条文上，而将一些深邃的医学理论蕴含于方证条文之中，所以给人的感觉是经方重方证而轻理论，但实际上经方理论的论理不但全面而且深刻。在论述六病的同时，将经方理论的绝大部分都集中到了“辨太阳病”篇，这就形成了经方理论一种特殊的论理方式。也就是全部太阳篇在论述太阳病的同时，还包括了经方基础理论的阐述，就是经方医学的病理、医理等内容。这些论理的内容又多蕴含于方证条文之中，势必不能仅仅只有干巴巴的几个跟太阳病有关的条文，所以这也正是在太阳篇中还包括了所有六种类型疾病方证条文的原因所在。例如典型少阳病的方证条文反而出现在太阳篇里，就是因为要在太阳篇论述这些道理。经方创立者把太阳篇既用来论述太阳病，又作为一个阐述基础理论的篇章。

六类疾病本身只包括了表证、里证和半表半里证的阴阳、寒热、虚实等病理要素。经方理论把气、血、津液这一类的病理要素以方证条文的形式，掺杂在六经论述和杂病论述中了。所以学习经方理论，只有在正确理解六病本质的同时，再以其蕴含的理论和方法进一步理解气、血、津液等相关论述，才能全面地掌握经方医学整体病理辨证施治的理论体系。

在经方理论中，六病辨证只是整个辨证体系的一个重要组成部分，不是全部。例如五苓散证、猪苓汤证（猪苓汤还有里热的因素存在）、泽泻汤证都是典型的水证；桂枝茯苓丸证、抵挡汤证、抵挡丸证等属于血证类的方证；旋覆代赭汤证、橘枳姜汤证等属于气证类的方证。还有很多方证都不能合理地概括到六病中，而后世医家在长期临床应用和对经方理论研究的基础上，总结出诸如六经、八纲、气血津液等各自自成一体的辨证方法。仔细推敲，假如把六经、八纲、气血津液等辨证方法科学地整合为一体，并用经方理论的观点来诠释，它们其实已经包含在经方辨证的病理要素中了，但这些病理要素之间客观存在着错综复杂的关系，却因为这些辨证方法都是各自强调自家的观点，所以没有把真正的正确的内容反映出来。

我们今天在胡希恕经方学术思想的启迪下，形成了一个经方病理辨证的整体架构，更进一步地明确了各种病理要素之间的相互关系，不仅能够最大限度、恰当地涵盖所有的经方方证，而且应用于临床实践对于辨证施治和提高临床疗效都有着非常重要的指导作用。

经方医学的疾病就是方证，在经方医学的病理辨证体系中，凡是方证都必须具备两大方面病理要素：一个是“疾病类型”，如表证、里证、血证、水证等；另一个是“疾病性质”，如阴阳、寒热、虚实。

在“疾病类型”这个要素中，除了六病中的表、里、半表半里之外，还包括气、血、津液这样的病理要素。这就形成了“疾病类型”的六大项病理要素：表证、里证、半表半里证、水证、血证、气证。

各自都有典型的方证，表证有桂枝汤证，麻黄汤证；里证有理中汤证，承气汤证；半表半里证有小柴胡汤证，柴胡桂枝干姜汤证；水证有五苓散证，泽泻汤证；血证有胶艾汤证，桂枝茯苓丸证；气证有厚朴生姜半夏人参汤证，桂枝加桂汤证。

另外，每一种类型的疾病都会发生不同性质的疾病状态，这就是“疾病性质”要素。或表现为机能沉衰的阴性证，或表现为机能亢奋的阳性证；或为寒性证，或为热性证；或为虚性证，或为实性证。这就形成了“疾病性质”的六大项病理要素：阴阳、寒热、虚实。比如里证中有阴性的四逆汤证，阳性的调胃承气汤证，寒性的吴茱萸汤证，热性的白虎汤证，虚性的理中汤证，实性的小承气汤证等等。

同时，不同类型的疾病之间也存在着同时发病的并病关系。比如表证与半表半里证同病的柴胡桂枝汤证；表证与里证同病的桂枝人参汤证、麻杏石甘汤证；表证与水证同病的小青龙汤证、麻黄细辛附子汤证；表证与气证同病的桂枝加桂汤证等等。另外，不同疾病性质的病理要素之间也存在着相互错杂的现象。比如既有阴性证、又有寒性证、还有虚性证的四逆汤证；寒热错杂的三个泻心汤证、乌梅丸证等等。

再进一步深入分析，不同的疾病要素之间对人体的影响程度也不同，也存在着“优先等级”的差异。比如表证与半表半里证同病时，因为半表半里证对人体的影响比表证大，所以在辨证施治的过程中要列为优先因素，可以不治表证，但不能不治半表半里证；表证与水证同病时，水证的因素又重于表证等等情况。只要从这个角度去看问题，这些在方证里都有。

同时，在不同疾病性质的阴阳和寒热之间，阴阳对人体的影响要大于寒热，所以当寒热与阴阳同时出现时，寒热的属性随阴阳的属性而变。比如在寒热属性中，热证本为阳性证，但是当出现在阴性证的方证中时，它随着整个方证的属性而改变，此时的热也为阴性证。例

如肾气丸证本身是个阴性的虚热证，所以这个热单独看寒热时为阳性证，但在肾气丸中虽有热也是阴性证。另外在虚实属性中，实证本来是阳性证，但是当出现在阴性寒证中时（实证与阴性寒证同时出现），它反而随着阴性寒证的属性而变为阴性。比如大黄附子汤证等等。可见在疾病性质的要素当中，阴阳属性居于首位，其次是寒热，再次是虚实。这些内容都反映了疾病与人体、疾病与疾病之间的关系。所以后世首辨“阴阳”的说法还是比较靠谱的，但这也要看怎么去理解，理解正确的话在临床中可作为一个原则，先辨清了阴阳再去辨别的。

另外由于表证的特殊性，决定了表证没有寒热属性，所有表证中的寒热因素或为里证之寒热，或为半表半里证之寒热。表证本身所表现出来的寒热状态，例如体温升高等等的，只是疾病的表象而不是疾病的本质，对表证的治疗没有实质的影响。

还有由于半表半里证的特殊性，凡是半表半里这一类疾病比较少有寒实证，不能说绝对没有，但就是比较少。

所有这些都客观反应了人体患病后的内在规律。但为何这些病理要素之间的规律以前很少有人来系统的归纳总结，究其原因是对经方的理解在方向上存在偏差。我们现在比较系统地归纳整理，也只是起到一个抛砖引玉的作用，对经方的研究还有很长的路要走。

这样以来，所有的经方方证就形成了一个涵盖人体全部典型病理状态的立体纵横交错的、复杂异常的病理关系网络，每一个方证都是这张网中的一个或多个结点。

事实上，多数方证都不是由一个单一的病理因素构成的，另外再加上合方这方面的探索，再加上方剂的加减，整个经方体系就形成了可以涵盖所有病理要素的无数组合，这本身也反应了人体患病后的状态是非常复杂的。

我们由上面的这些分析总结，可以得出以下结论：

经方医学是一门通过人体患病后所表现出来的症状反应来研究

人体所处的病理状态，并在此基础上给出施治方案的医学。

由于经方医学本身就是一种经验医学，所以在经方理论中疾病的最小单位就是具体的症状反应，甚至可以再提高一点：疾病的最小单位就是方证。当然如果要考虑方剂加减的话，也可以再具体点，最小单位就是症状。但人体患病后的症状反应却是非常复杂和形式多样、变化多端的，无法用任何一个单一的具体的症状反应来确定疾病的类型和性质，只有通过四诊合参、症症相佐才能最终辨出真正的病理属性。最后在这个基础上，再确定具体的某一个方证，或者某几个方证。

但是方证本身又不是一个固定的症状群，而是一个动态的症状范畴。每一个方证都没法用特定的模式固定下来，任何一个方证的最终确定都需要临床医者进行周密地思考和认真地分析，经过一个从症状到病理再到方证的辨证过程之后才能完成。这就是经方医学的特点，也是经方医学的难点。今天学经方为什么很多人走不进来？为什么很多人坚持不下去？为什么在短时间内不能像时方那样容易掌握？原因就在于此，但是中医的最终出路只有经方这一条。

厥阴病小结

李冠杰：到此整个厥阴篇就学完了，厥阴篇本身条文不少，但都非常简单，此外跟厥阴病有关的条文也非常少。下边做个简单小结：

首先整体看条文，按《宋本》计算厥阴篇总共有 55 条。但顶格条文只有 5 条，降一字格条文有 11 条，降两字格条文有 40 条，加起来要超过 55 条，因为第 366 条在《康平本》里是两条，在《宋本》里是一条，另外排版方式也不一样，因此就重复计算了。

第二，我们下个定义，厥阴病在经方理论中是阴性证。如果把这一篇提纲条文中的旁注内容（“消渴”）剔除出去，其论述的正是在半表半里阴性证的病理状态下所表现出来的典型症状反应。事实上在整个厥阴篇所有条文中真正论述厥阴病的就只有本条和第 338 条（降一字格乌梅丸证的条文）这两条。尽管条文非常少，但已经把厥阴病的性质和症状反应论述得非常清楚了。

第三，在太阳篇有个与厥阴病关系比较密切的方证，就是第 147 条的柴胡桂枝干姜汤，这是经方中在病理属性上最接近厥阴病的方证。大家都知道胡老生前的挚友经方家陈慎吾曾经说过，柴胡桂枝干姜汤方证有“阴证的转机”，他这样说的原因就在这里，这个方证在病理上与乌梅丸证是一样的，都属于半表半里的虚热证合并里虚寒证。但两个方证在阴阳属性上存在着程度上的不同，柴胡桂枝干姜汤

方证从临床应用看，这类患者确实有阴性证的特征，比如萎靡不振、体乏无力一类的症状，但与乌梅丸证相比较其阴性证不是那么典型，然而其也能佐证厥阴病半表半里这类疾病的病理属性。

厥阴篇小结就说到这，厥阴篇其他条文跟厥阴病几乎无关，在学习过程中也和大家讨论过了。

辨厥阴病 霍乱^①

注：《宋本》作“辨霍乱病脉证并治第十三”。

问曰、病有霍乱何^①、答曰、呕吐而利、此名霍乱、（382）

注：“病有霍乱何”《宋本》作“病有霍乱者，何”。

胡希恕：这个霍乱病啊，啊…古人给起名儿叫霍乱。就是，啊，这个病是暴来啊。挥霍缭乱嘛，上吐下泻这一类的病，它是个急性传染病，这一个大家都知道。我对这个病有经验，嘿！我亲临其境遇到这么三次。现在这个病少了，可是这个也要知道，这个病还是…在这个乡村有时候还是有。

“问曰：病有霍乱者何？答曰：呕吐而利，此名霍乱。”他说什么叫做霍乱呐？那么主要的就是上吐下泻，啊。那么这一个也类似伤寒，开始他是表里一起病，啊，但是这个上吐下泻这个相当厉害。这个病死人的快，一脱水就死啊。那么这一个，他只是提出这个上吐下泻，他并没说明这一个病的详细情况。他底下第二节儿，说得清楚了。

李冠杰：这一篇的题目在《康平本》里是“辨厥阴病霍乱”，在《宋本》里是“辨霍乱病脉证并治第十三”。所以仔细推敲《康平本》

中的“辨厥阴病”四个字出现在篇名中就十分可疑。不仅厥阴病与霍乱病在疾病属性上是完全不同的疾病，而且厥阴病跟本篇里论述的内容也没有直接关系。另外《宋本》的篇名没有这四个字，也是一个很好的说明。现在就只能把“辨厥阴病”这四个字当闲文看，这是多余的文字。至于为什么会这样，现在也没有直接证据，只是一些猜测，与其猜测还不如当闲文就行了。

这条在《康平本》里是降两字格排版的条文。

条文中的“病有霍乱何”在《宋本》里是“病有霍乱者何”，多了一个“者”字。本篇条文中这类情况挺多，并且能说明问题。这里先跟大家讲一下，后边这类问题显得尤为重要。凡是这种加了字的大部分都是降两字格排版的条文，而且通过这次学习我们发现王叔和曾经第二次整理过本书，这明显是他第二次整理时感觉语句不太通顺又加上的。这也佐证了一个问题：原文中顶格排版的条文和降一字格排版的条文在有的地方明明少字，而且那个字大概也能补个差不多，但在《康平本》中都保持了空缺的符号，而大部分降两字格排版的条文就不是这样了。虽然个别情况也有缺字的地方，那大概是在王叔和之后了，好多地方都属于这种情况。两个版本不同的地方都是在加减字，明显的是有润色、修改的痕迹，说明降两字格排版的条文很可能就出自王叔和之手。他自己改自己的条文，就可以毫无顾忌地去改，因为是他自己写的。就像我们认真地写一个稿件的时候，往往要修改几次，道理是一样的。

下边解读一下：

直译：问：霍乱病是个什么样子的？答：呕吐而利的，称为霍乱。

实际上“霍乱”就是一个病名，泛指突然剧烈吐泻同时伴有心腹绞痛这类的疾患。按照规范的定义，其中包括两大类：一类指的是剧烈吐泻，同时又有传染性的病症；另一类指的是严重吐泻但不传染的病症。由此可见，这条论述的就是霍乱病的主要症状反应。无论是哪

一种，都是以剧烈的呕吐和下利为突出的症状反应。这一类的疾病之所以称之为霍乱，就是因为病势迅猛，而且呕吐和下利都非常的剧烈，稍有延误可能导致患者脱水而发生危险。

问曰、病发热、头痛、身疼、恶寒、吐利者、此属何病、
答曰、此名霍乱、霍乱自吐下、又利止、复发热也①、（383）

注：“复发热也”《宋本》作“复更发热也”。

胡希恕：“那么这一个就是…承上头那一节儿，详述其证。就对霍乱这个病证啊，又详细说了一下子。那么这个病之初作呀，像一般的这个，啊，这个外感伤寒一样，也发热、头痛、身疼、恶寒。但是同时呢？他又有吐利，上吐下泻。所以这个表里一起来，那么这一个，所以管它叫做…啊…霍乱。这个霍乱呐，啊，它是自吐下。不是有其它的原因，他那病一来就自吐自利。那么他…啊…吐下，有的时候也就不吐不下了，就是无可吐下，到那么个地步，他就是下利和吐也止。但是呢，要如果病不是好的样子，他还是“更发热也”，啊，那就像，啊，就有这么一句话了，说昔是霍乱今是伤寒，那霍乱过去了，后来就类似伤寒的病，啊。不是好，要是真正要是好呢，他还不是这样子。所以这一个病与我们讲那个《伤寒论》头前儿也有关系的，他这个是暴吐暴下呀，就是胃肠里头啊，纯粹的这是一个，啊，所谓这个痛，啊，痛泻那个样子，所以虽有表证，也要舍表救里，不能够管这个表证，不要拿这一个当作太阳阳明合病，一吃葛根汤，就坏了，啊。所以我们在平时用这个发汗药啊，有这么，古人有这么几句话，啊，渴而下利，啊，小便复利，啊，渴而下利，渴又下利就说明怎么得，丧失水分了。或者是小便频利、数，这都不能发汗。我们说那个太阳阳明合病啊，它只是有表证，但是他下利而已，他不是…啊…没丧失津液，他不是那么渴，真要是我们遇着那种渴又下利又吐，这你千万不要根据那个太阳阳明合病，啊，用葛根汤又加半夏那更不行了。所

以这就啥表救里了，他这个下利太厉害了，这人身上这个…这个水份马上就是没有。

李冠杰：这条在《康平本》里也是降两字格排版的条文。条文中“复发热也”在《宋本》里是“复更发热也”，多了一个“更”字。解读一下：

直译：问：患病后表现为发热、头痛、身疼痛、恶寒、吐利的，属于什么病？答：这种病名为霍乱。霍乱病自吐下，即使是下利止后，还会有发热的症状。

这条论述的是霍乱病一种比较典型的表现形式。“病发热、头痛、身疼、恶寒”看上去类似于表证的症状反应，但同时还有吐利的症状，而且这个吐利不是一般的吐利，跟葛根汤证或桂枝汤证中出现的以表证为主要病理的情况下发生的下利完全不同。这是一种来势非常迅猛，甚至是吐泻无度的吐利。所以这时虽然可能有表证的因素存在，但疾病的主要矛盾是里证。即使有表证，按经方的治疗原则也应该先治里证。所以条文就明确地说这是霍乱，言外之意这不是表证，这样理解就比较合乎霍乱病的本意。

因为霍乱的吐下并不是由于误治造成的，所以条文说“霍乱自吐下”，就是往往没有外界因素自己就发生了吐下。这种吐下因为来势凶猛，在较短的时间内就有可能出现无物可吐下的情况，因为过度吐下造成无物可下，而出现了“下利自止”，下利反倒是停了。但这种下利自止不是疾病向着痊愈方向发展的证候，所以虽表现为下利暂时像是止住了，但患者还会表现为发热这一类的症状，也就是条文里说的“霍乱自吐下，又利止，复发热”。

伤寒、其脉微涩^①、本是霍乱、今是伤寒、却四五日、至阴经、上转入阴、必利、本呕下利者、不可治也、欲以大便^②、而反失气、仍不利^③、此属阳明也、便必硬、十三日愈、

所以然者、经尽故也、下利后当便硬、硬则能食者愈、今反不能食、到后经中、颇能食、后过一经能食④、过之一日当愈、不愈者、不属阳明也、（384）

注：

1. “其脉微涩”《宋本》作“其脉微涩者”。
2. “欲以大便”《宋本》作“欲似大便”。
3. “仍不利”《宋本》作“仍不利者”。
4. “后过一经能食”《宋本》作“复过一经能食”。

胡希恕：“伤寒，其脉微涩者，本是霍乱，今是伤寒，却四五日，至阴经上，转入阴，必利。”这是一节儿，啊。他说伤寒呐，其脉微涩。微涩就是这个，啊，津液虚，津液血液俱不足的样子了。这是什么道理呢？伤寒怎么能这样子呢？由于他本是霍乱呐，他得的时候啊，就是呕吐下利。那么这时呢，啊，“今是伤寒”，他呕吐下利止了。这就根据上一节儿说得这个问题，啊，所以呀，现在只剩一般伤寒的这一种情况了，那么这个呀，不是好现象。要是好，这样子慢慢他就是，啊，大便干了就好了。这一个“却四五日，至阴经上”，这指着这个伤寒说了。那么这个他是当时无可下利了，啊，吐利了，所以他吐利都止了。那么再到个四五天，那么到这个阴经上，又是到，啊，说这伤寒传里的时候，那么他还要下利的，啊，还要“必利”。这一个后头有，怎么治疗他有的。这是…这是一条儿。还有一条呢，他就是始终不利了，就是好了。本呕吐下利者，啊，不可治也。他说以前他是呕吐下利来，霍乱，那么现在呢，只是脉微涩而不下利了，可是脉微涩没正常你可知道啊，啊，他是这个下后太虚了。这样子啊，你要好好观察，啊，他本来是霍乱那个呕吐下利，现在这个是应该的，这个“脉微涩”是应该的，啊，他要逐渐恢复的，不要瞎治。“不可治也”，啊，这个阵儿你看他虚，瞎给补，这可不行。“欲似大便而反矢气”，这底下这都是接着这一句话。他要大便，但是而反矢气。

已经不利了，虽然转矢气，啊，就像拉似的，可是还是不利，啊。“此属阳明也”，这是属于胃气恢复那个样子，属于胃，啊。这个阳明它指着胃说的，不是指阳明病说的。“便必硬”，啊，这是胃气恢复，啊，他所以这个，津液还是不那么充足了，所以脉微涩，但是以后慢慢的大便它要硬了。“十三日愈”，这都是约略之词啊，一般说都是十三四日就要好了。那么古人他要解释，为什么十三日好呢？啊，这是“经尽故也”，啊。六日一个循环嘛，十二日两周，啊，那么到第十三天又该…啊，转属阳明了，所以这一个，既是胃气恢复了，到这一天他一定要好的，这是古人的看法儿，其实这一个没什么大意思。那么就是这个病啊，这个阳明病…啊，阳明病了，这个霍乱病，就是下利止，那要是…如果是好的样子，尽管其脉微涩，啊。这个慢慢能恢复的。恢复得多少天呢？一般是十二、三天，啊。这是说不可治。这一个，啊。这是，这一节儿是两个意思：头一个不是个好样儿，虽然暂时止了，他以后就变成一个虚寒下利。那还是很严重，是吧？第二个呢？干脆他是好了，可是这个脉呢，还是微涩，这一阵儿可不要胡治，啊。吃热药更不行。那么这一个你看看情况，啊，他这个逐渐逐渐胃气恢复大便硬，就是完全好了。为什么大便硬啊？津液丧失太多了。他不像一般那个闹肚子，啊。闹肚子，比方闹痢疾吧，他一点点大便成形儿；这一个他不是的，这一个丧失水分太多，这个胃肠里头没有什么东西了，所以他这个…啊，有屎出来是干的，这也是霍乱病的一个特殊情况。这因为要两条儿了，啊。啊，第四条儿，下利后，便当硬，硬则能食者愈；今反不能食，到后经中，颇能食，复过一经能食，过之一日，当愈。不愈者，不属阳明也。这一个也就是在这个，啊，这是根据这个…第…上边这一条儿的第二个部分，就是霍乱病，已经不吐不下了，啊，脉微涩，他逐渐大便要硬了。所以“下利后，当便硬”啊，这指着这个霍乱病。要是硬呢，这是胃气恢复了。“硬则能食者愈”，啊，这胃气完全恢复。“今反不能食”，因为这个

大吐大下之后啊，这个胃气也是虚，大便可是硬，但是他不能吃东西。

“到后经中，颇能食”，你还要观察观察，就是头六天不能吃东西，转入后经了，哎，他能…慢慢他能吃东西了，就是胃气在这时候他恢复了，这也没问题了。那么在后经中，这一经就是一个六天，都好，那么到第十三天也一定要好的，啊。“过之一日当愈”，如果过之一日，啊，还不好。还不好那就是能吃，但是而…病是不好的，啊，还是拉不下屎来，他是这一…这一种意思。这一个就是“不属阳明也”，啊。你不要看着胃气恢复了，是老不治也不行，这一个时候一定要随证而治之啊，话是没说。这一种情形也是少了，啊。一般要是大便硬了，霍乱是可好的；也有他丧失水分太多，啊，啊…那么肠胃一时这个…啊，虽然能食，大便始终不通这个事儿也是有的，这一个根据当时的情形，啊。但是用这个承气汤的机会很少。这一个也就是说用这一个，啊。咱们所说这个蜜煎导的法子啊，啊，或者用这个麻仁丸这一类的，啊。总之要少给他用这个攻破药才好呢。

李冠杰：第 384 条文字比较多，但内容却不怎么好。条文读起来有点像绕口令，其实并没有什么深意，在《康平本》里也是降两字格排版的条文。

需要注意的是条文中四处有两个版本之间的文字上有微小的差别：“其脉微涩”在《宋本》是“其脉微涩者”；“欲以大便”在《宋本》是“欲似大便”；“仍不利”在《宋本》是“仍不利者”；“后过一经能食”在《宋本》是“复过一经能食”。这个很可能是王叔和老人家这时不知哪来的雅兴，非要把自己的文字修改到自认为满意为止，这篇明显比其他地方修改的多。实际上这类情况就类似于我们用写笔记或写心得的方式在学《伤寒》的过程中，就会发现有时的侧重、角度、语言等都会随着当时的情绪有所变化，风格也会有较大不同。这里大概也有这方面的原因，他恰好有兴致，能比较细致地去揣摩自己的文字并加以修改。

直译：伤寒，但却现脉微涩，这原本是霍乱病，而刻下只余伤寒的症状，过四五天之后，如果发展为里虚寒证，则可能出现下利；那么本来就有呕和下利的，不可治。如果有欲大便之意，但反而矢气，并不下利了，就是已经发展为阳明里热证了，则可能会出现大便硬，这要等十三天左右才可痊愈。之所以如此，是由于疾病发展到阳明病就不会再发展了。最初为下利，然后出现大便硬，此时患者如果吃东西正常，则会痊愈。如果反不能吃东西的，再过六七天食欲就会好转，再过六七天食欲仍然正常的，过一天就可以痊愈。如果不能自愈的，就不属于阳明病。

这一类条文可以自己慢慢揣摩，我们就只做个参考，真正临床价值不是很大。这条论述的就是霍乱或者与霍乱类似的一类吐利的疾病的转归和预后。

吐利恶寒^①、脉微而复利、利止亡血也·回逆加人参汤^②主之、

(385)

注：

1. “吐利恶寒”《宋本》作“恶寒”。
2. “回逆加人参汤”《宋本》作“四逆加人参汤”。

甘草三两^①炙 附子一枚生去皮破八片 干姜一两半 人参一两

注：“甘草三两”《宋本》作“甘草二两”。

右四味，以水三升，煮取一升二合、去滓、分温再服、

①

注：《康平本》中此方排版较为特殊，方药为降一字格，方后注却为顶格，当为笔误。

胡希恕：第五节儿，“恶寒脉微，而复利”，这就是，啊，承着这个上边那个第三节儿，“转入阴经必利”那一节儿，这是承着那一节儿说的。我才刚才说嘛，后头有治法，就指着这一节儿说的。他说

啊，先是呕吐下利，后来呕吐下利止了，可是脉又微又涩，啊，那么转入阴经，他又下利了，就指着那一节儿说的。所以这一节儿他一开始就说，“恶寒脉微而复利，利止，亡血也，四逆加人参汤主之”。这一个利止啊，只是…不是他这又利止了，这是指着这个霍乱病呕吐下利那一个“吐利止”。那一个利止，不是病好了，“亡血也”，亡津液亡血液到家了。这个体液尽量，啊，亡失了，他就是没有什么可下可吐的了，所以他，啊，吐利止，这么止的。那么这一次“恶寒脉微而复利”，就是那个利止之后又转入阴证，这恶寒脉微而复利嘛，啊，你看他不发烧，这就是咱们讲这个太阴病这一种下利了。源起那一个“吐利之所以止”不是病好，是“亡血也”，亡津液亡血液的关系，啊。那么这一回他又复利，啊，“恶寒脉微而复利”，这就用四逆加人参汤啊。为什么用四逆加人参汤呢？他这个阴寒下利，本来他用四逆汤。由于亡血，他这津液丧失太多了，啊，加人参健胃益气。咱们知道人参是益气，益什么气？就是滋津液，啊。咱们说中气，中气就脾胃之气了，那么，得恢复胃，胃气恢复了，才能…啊，布谷气而生津液，要不哪来的津液呀！所以这一段呐，这个注家就是…尤其这《医宗金鉴》，啊，嘿！这个太医院的人瞎胡闹啊。他一看亡血，亡血怎么还用辛温热药呢？这病啊，咱们讲那一个，嗯…三阴篇大概明白了，这个没有用…所谓甘寒滋阴的？没有那么用的。一用人就完了。他这胃气不恢复啊，你津液没有。你非恢复这个胃气不可，啊，这…化谷生津嘛！没有胃气你津液哪来的？所以这个时候，啊，《医宗金鉴》还…还那么搞呢。你们看看他那个注解就知道了。他说“亡血”也不对，是亡阳，给瞎改，乱七八糟的，胡说八道。这就是，啊，根据那一条儿，就是昔是霍乱，今是伤寒，是吧？他是吐利止，那么却四五日呢？止了几天，转入阴经，他又下利，就是这一个而复利。那么那个霍乱止哪一天呢？就是这个利止。为什么利止？由于亡血。它是，它是个倒装句儿啊，它是，啊。这个就四逆汤加人参。咱们说是

这个阴寒下利，啊，脉微欲绝，或者是手足厥冷，下利清谷这都是用四逆汤喽，啊。但是由于津液已经亡失太多，所以加人参。这个人参的加法跟那个白虎汤加人参一样。白虎汤加人参，啊，他是在这个白虎汤证，这个热的基础上，津液丧失了，所以他烦渴，啊，大烦渴欲饮水数升，你非加人参不可，啊。那也不能，也不能搁滋阴药。这一个也是一样的。阴寒，真正的，啊，人身上这个体液丧失太多，也得加人参。那么这个方子呢，就是四逆汤加…加一味人参。所以它治四逆汤证，啊。那么另外呢，就是津虚血少。

李冠杰：这条在《康平本》里是顶格排版的条文。“吐利恶寒”在《宋本》把“吐利”去掉了，就只有“恶寒”两个字。“回逆加人参汤”在《宋本》里是“四逆加人参汤”，跟四逆汤条文是一回事。解读一下：

《康平本》在条文之首有“吐利”两个字，但到《宋本》中就没有了，这显然不是传抄的笔误，一般这类笔误很少出现。一种比较大的可能性就是王叔和在第二次整理时特意给改掉了。这种情况在这本书里还真不多，这条也是趁着雅兴改的。原因是条文后面有“脉微而复利”，就是后边又有一个关于下利的论述，觉得好像跟前面的“吐利”有重复，就去掉了。在顶格条文论述的所有霍乱病里基本上都有“吐利”这个症状，所以从条文的文意分析，这个“吐利”在这条里就不是一个单纯的述症了，同时还有明确疾病性质的作用。因为这一篇的题目是以“霍乱”命名的，所以这儿的“吐利”自然就是指“霍乱病”而言。顶格条文在这一篇里没有所谓的提纲性条文，所以每一条中差不多都有“吐利”。篇名又是霍乱，因此这个“吐利”指的就是“霍乱”。“霍乱”是什么病？就是“吐利”。

“恶寒、脉微而复利”，则明显是指之前的“吐利”虽然自止（暗含前边的“吐利”有自止的经过），但疾病并没有痊愈，后面又出现了下利。“恶寒、脉微”是由于之前的吐利过度，使人体津液严重虚

损并陷入阴性证的一种症状反应。呕吐下利自止后，又出现了下利的状态，这是该条文的一个关键点。本来是霍乱病，但是严重地吐下后症状自行停止，一般有两种可能性：一种是疾病向痊愈的方向发展，随着人体机能的恢复，慢慢吐利的症状也消失了；或者再变成其他类型的比较轻微的病，那是另一个问题了。另一种是由于吐利过度，腹中无物可吐下而出现自止。这条论述的就是后一种，虽然吐利自止了，但却表现为“恶寒、脉微”，还有其他的症状在，这是由于吐利太过造成人体津液虚竭并陷于机能沉衰的阴性证的证候。所以随着人体腹中摄入食物的增加，随着饮食有一点补给、肚子里有东西之后，又开始出现下利的症状。这一类情况，在经方的治疗上就要用四逆加人参汤。旁注“利止亡血也”加入得还是比较恰当的，可以帮助读者理解前文中已经含有吐利自止的这个过程，但其中“亡血也”应该理解成主要还是“亡津液”。霍乱吐利这种病来势比较猛，短时间内就可以造成脱水。

四逆加人参汤证的病理是：阴性的里虚寒证合并水虚证（津液虚）。

小结：本为吐利的霍乱病，吐利之后出现恶寒、脉微的症状，而后再重复出现下利症状的，为四逆加人参汤主治之证。

下面看看方子。该方子由四味药组成：甘草、附子、干姜、人参。实际上就是四逆汤加人参一两，但要细推敲它的量的话，甘草也加了一两。人参在方剂中的作用与其在白虎加人参汤中的作用一样，主要是用来改善人的胃功能，增加胃对水分的吸收，进而改善人体津液虚损的状况。

《康平本》该方剂中的甘草是三两，《宋本》是二两，也就是《宋本》是在四逆汤原方的基础上加了一两人参，而《康平本》可以视作是甘草干姜汤与四逆汤合方的基础上又加了一两人参。那么有什么意义吗？实际上加这一两甘草对疾病的治疗方向不会有质的影响，但如

果理解成甘草干姜汤与四逆汤合方的话，它应该比没有这一两甘草对于人体津液的恢复要有意义。

另外还有个问题值得一提。方剂的方后注解在《康平本》里为顶格排版的条文，但方子却是降一字格排版的，这就能看出方后注解的排版方式显然是抄错了，这是最明显的笔误，没有别的解释。不可能方药都是降一字格排版的条文，单纯一个方后注解是另外一个人写的，这是不可能的事，这肯定就是笔误。为什么要特别强调这个？这提示我们对于《康平本》中不同的排版格式也不能绝对地、僵化地、机械地去看，应该结合内容客观地分析。所以关于条文中文字加减的问题和排版格式的问题，都应该客观地看。

下面看看四逆加人参汤的方证，从症状上看临床表现最多的是四肢厥逆，其次是面色苍白、冷汗淋漓、腹泻、心悸、头晕、目眩、神疲神昏、呕逆、少气懒言、腹痛、恶寒、发热、消瘦、四肢酸痛。

舌质：以淡舌为主，另外还有淡红舌、胖嫩舌。

舌苔：以白滑为主，还有无苔、少苔和薄黄苔。

脉象：以沉脉、微脉为最多，其次是弱脉、迟脉、细脉、弦脉、虚脉、伏脉、还有无脉的情况。

现代疾病大致有：中毒性休克、心源性休克、失血性休克、肺源性心脏病、风湿性心脏病、冠心病、心肌缺血、心肌梗死、心动过缓、肺结核、高血压、低血压、心力衰竭、支气管扩张、尿毒症、中毒性腹泻、急性胃肠炎、急性胃肠炎过度吐泻及休克、肝昏迷、麻疹、麻疹后泄泻危症、吐血。

吐利头痛发热、霍乱·身疼痛、热多欲饮水者、五苓散主之、寒多不用水者、理中丸主之、①（386）

注：《宋本》此条文如下：

霍乱，头痛发热，身疼痛，热多欲饮水者，五苓散主之。寒多不饮水者，理中丸主之。

1. 《宋本》此处有五苓散方及方后注，此从略。

人参 干姜 甘草炙 白术各三两

右四味、捣筛、蜜和为丸、如鸡子黄许大、以沸汤数合、
和一丸、研碎温服之、（注）日三四、夜一服①、

注：“夜一服”《宋本》作“夜二服”。

腹中未热、益至三四丸、然不及汤、汤法以四物、依两
数切、用水八升、煮取三升、去滓、温服一升、日三服、

若脐上筑者、肾气动也、去术、加桂四两、吐多者、去
术、加生姜三两、下多者、还用术、悸者、加茯苓二两、渴
欲得水者、加术、足前成四两半、腹中痛者、加人参、足前
成四两半、寒者加干姜、足前成四两半、腹满者、去术、加
附子一枚、服汤后、如食顷、饮热粥一升许、微自温、勿发
揭衣被、①吐利止、而身痛不休者、当消息和解其外、宜桂
枝汤、小和利之②・③（387）

注：

1. 《宋本》自此处另起一段落。以上内容为理中丸方后注，以下为第 387 条。

2. “小和利之”《宋本》作“小和之”。

3. 《宋本》此处有桂枝汤方及方后注，此从略。

胡希恕：386 条：那么这个就是根据那个第二条儿，就是霍乱之
初来，啊，他也是头痛发热，身疼痛。如果他欲饮水，渴的厉害，啊，
是渴这都是胃有热了，这时他说是热多，不是这而外另有什么热，不
是的。就是，欲饮水者，这就是…可见是热多，这个时候可以用五苓
散，啊。这个五苓散，啊，一方面解表，啊，分解这个水了。这个水

一分解开，这个吐利也就好了。“寒多，不用水者”，一来里头就虚，虚就生寒了，啊。他一点水不想喝，虽然也头痛、发热、身疼痛，应该舍表救里，啊，用理中汤。理中丸不如理中汤，他，他这一个搁个理中丸，还是用理中汤好。所以呀，一样儿病是得辨证啊，这…这个，啊。那么古人说是多热多寒，啊，就看他渴不渴。他渴呢，欲饮水，啊，说明这个热多，这一个用五苓散是没问题的。我看着哪个医书来，就是北京在…大概在金的时候啊，也不知在什么时候，这个朝代我记不清了，大疫呀，就是闹这个…啊，虎烈拉。（音频 040 完）（音频 041 始）我用这一个就治过。这个白矾这个药非常好。真正的霍乱呐，他拉那个，什么样儿？拉那个不是一般的屎啊，见不着啊。就是红水汤子，啊！那是没完没了的，要不他人怎么渴呢？就这个白矾呐，挺好。白矾这个东西呀，它起一个…啊，它那个东西是挺苦挺酸，可是要有这个病的人他喝香，啊，啊…我那是没办法了，在我家里头，我家…因为那一阵儿我回去了，在这个胜利那一年。回去我打算在家开个小药铺算了，嘿！养老，打算那么样子。好！到那儿找不着房子，那个房子大家乱抢。那时候我在北京认识一个姓马的大夫，他以前在这个华北医学院。他直门儿跟我说，他说您老走把我带去吧，在这儿我…搞不出饭吃来。那伶俐毕业的学生，伶俐在北京市考取的大夫啊，那一阵儿是，搞这个自己在家开业是不很好，啊，没人儿找，嘿。他直跟我说，我就说好吧。我就他带回去了，带回去了，还没等给他往外介绍事儿呢，他在我家住着，他就得着了。他招呼我，我在楼上住，他在这楼底下。他就是…他就招呼我，我下去，他说我不好，我说怎么办呢？我霍乱了！嘿，嘿，那阵儿沈阳闹得最厉害。那这正是一个…一两点钟的时候了，从外头买药也…也来不及了，他那个…那时候还，市面上不很太平。我说怎么办呢？还不敢声张，一声张了这一家子人就坏了，就给你隔离开了，啊。我说得了，我就上厨房，我问说有…有没有这个白矾，家属说有，我就弄了挺大一大块，嘿！

浓浓的我给他弄了，啊，一大碗，我说你喝吧，嘿。他就喝了，哎，！喝完他就好了。你看这个东西，啊，这个我亲身有体会，这个白矾这个药最好。也有的时候，啊，真正虚寒，那是得用理中汤，啊，不到那一个地…地步啊，他还是有热多的多，啊。那么这个时候啊，我没说嘛，有用白虎人参的机会，也有合用，啊，白虎加…白虎加人参有合用五苓散的机会，五苓散用面子，啊，另外给他用吃白虎加人参，这我都这么用过。单独的像这一个样子，啊，五苓散证与这个理中汤证啊，比较少见，但是这个方法儿是对的，啊。他如果要是渴得厉害，啊…这一个可以表里双解，啊。用这个一方面利水祛热，一方面解表。你要是不渴，不渴这个就是阴证了，咱们头前儿所说，啊，下利不渴者，啊，属太阴呐，以其脏有寒故也。这根据那一个…那个来的。所以这个时候呢，是一种这个解热的药不能用，啊，就用这个理中汤。这个理中汤，咱们头前儿也讲过，就是人参、甘草、干姜、白术，啊。他是用人参、甘草，啊，这都是健胃安中的药了；干姜、白术这是温中祛湿的药了，祛…祛水了。所以这个腹痛，啊，哦，腹痛了…呕吐下利，啊，由于胃虚有寒，这个药，它叫理中嘛，很好，啊。那么这个霍乱还是由胃而来的。

387 条：这霍乱这一章挺…重要。吐利止，而身疼不休者，当消息和解其外，宜桂枝汤小和之。那么这一个就指着这个服用理中汤了，吐利是好了。身疼而不休，就表证还是不了了，是吧？那么这一个呢“当消息和解其外”，啊。消息之，和解之，不要大发汗，只能够用桂枝汤小和之。这小和之啊，这个语气也很含蓄呀，就是我们用桂枝汤也用小剂量，啊，不要用大量。因为他那个，啊，体液丧失太多了，就是发汗也是微微让他似…微似有汗就完了。这跟我们讲那个《伤寒论》是一样了。先救其里，后救其表，是吧？里好了，表这儿，多少还有一些表证不了了，那么只能够用桂枝汤，这没有再大发汗的必要了。那就是错了。底下这几段是相当的严重了这个病，这都不是

初期了。

李冠杰：这条在《康平本》里也是顶格排版的条文。在《宋本》中将旁注“霍乱”移到了条文最前边，并把“吐利”两字去掉了，变成：“霍乱头痛发热，身疼痛，热多欲饮水者，五苓散主之；寒多不饮水者，理中丸主之”。另外在条文最后附有五苓散方和方后注解，《康平本》没有。解读一下：

这条论述了霍乱病较为典型的临床表现以及霍乱病两种最为常见的在不同病理状态下的鉴别和治疗方法。

再来看条文述症：“吐利、头痛、发热、身疼痛”，这是霍乱病典型的症状反应。所以再回头看第 383 条，实际就是降两字格排版条文作者把这条里的症状提出后又加了点别的症状，作为霍乱病的提纲性内容加以论述。而本条论述的重点是通过这两类常见的霍乱病，在症状上相同之处和不同之处都作了比较详细的论述，既阐明了霍乱病主要的症状反应就是呕吐和下利，同时也论述了如“头痛、发热、身疼痛”这一类霍乱病常见的症状反应，后面才是对常见的霍乱病中两种不同类型疾病之间区别的阐述。

“热多欲饮水者，五苓散主之”，这是在五苓散证的病理状态下发生的霍乱病，并且在该状态下发生的霍乱病表现出的特征性的症状反应就是“热多、欲饮水”。既然是霍乱，也是以呕吐、下利为典型症状反应，但同时也可能伴有“头痛、发热、身疼痛”这一类的症状。在病理上，这纯粹是一种由于消化道内停饮严重而造成的霍乱病。“热多”应该是指体温高，就是指“发热”，不是有里热。“欲饮水”则是因为体液代谢不良造成组织缺水的反应，这就和五苓散证的“渴欲饮水”是相同性质的问题。实际上这类疾病在临床中常表现为没有明显诱因的上吐下泻，大便常呈现稀粥样，并且就只是以吐利为主要症状反应，其它症状都不太明显。如果仔细问诊的话，这类的患者常在很多天前就已经存在小便不利这类的症状。凡是上述情况，以五苓散

治疗都能取得捷效，疗效都非常好。因为这种疾病是消化道内停饮，特别是胃中停饮造成的，由于吐的情况比较重，所以服散剂比服汤剂效果要好，散剂对于呕吐症状是比较有利的。

比如在临床中有一些小孩子，特别是在断奶前后因为胃肠要适应新的食物，所以会表现几天这样的症状，没有什么特殊的原因，突然就出现上吐下泻，实际这就是霍乱的一种。但这种霍乱不能算是重症，最起码没有里虚寒的问题，或者是里虚寒的问题不是特别重，另外也到不了阴证的程度。例如有些小孩出现这种情况后上吐下泻，吐完拉完他还玩儿，也不是特别痛苦，像这类情况用五苓散的机会比较多。我曾经碰到一个比较典型的，有个家长突然打电话说孩子又吐又泻。后来就问他有什么原因？他说，没觉得有明显的原因。我就给他五苓散，因为孩子两岁多，服散比较困难，就让他泡点水喝，不要用太多水。结果孩子喝了一次吐泻就止住了，后来又喝了两天巩固一下。

“寒多不用水者，理中丸主之”，这是在理中丸证的病理状态下，发生霍乱病所表现出来的特征性的症状反应。“寒多”指的是里寒的病理而言。“不用水者”则是由于里寒这种病理造成的胃中有停饮的情况，所以就不喜饮，这与第 277 条太阴病中的“自利不渴”属于比较类同的症状。

这一类霍乱主要的病理是由于里虚寒造成的胃肠功能低下所致，所以临床中常伴有纳呆、不能食、神疲乏力、腹痛这一类的症状。强调这个的原因是，五苓散证（霍乱）上述这一类症状就没有理中汤证（霍乱）那么明显，当然未必一点没有，但出现的几率比较低，而且程度上也绝对不如理中汤。

在《康平本》中该条文在“吐利头痛发热”之后有旁注“霍乱”两个字，但在《宋本》里把旁注弄到条文之首了，并用这两个字代替了原文中的“吐利”。如果细加推敲，会发现虽然吐利本身就是指霍乱而言，好像是替换了以后也没什么质的问题，但要纵观整个霍乱篇，

所有顶格条文都没有“霍乱”这两个字，而基本都有吐利这样的述症，因此这里顶格条文作者实际是要用这种方式向读者展示经方理论疾病的概念，所谓“霍乱”只不过在当时是一种比较常见的急性疾病。大家都说只要是上吐下泻就是得了霍乱了，但从经方理论来看，这种以吐利为主要症状反应的疾病，实际上包括了好几个病理状态下的，疾病性质完全不同的疾病。虽然都表现为吐利，但就拿五苓散证和理中丸证来说，从病理上就差很远，治疗上也根本不同。但是后人，恐怕也就是王叔和不单是在这一篇中编了一个“伪”的提纲条文，同时还对这一条做了更正，用“霍乱”把“吐利”替换掉了。这样更正之后，我们上面说的这层意思就荡然无存了，这条仅成了论霍乱病和论霍乱病怎样治疗的意思了。实际上原作者还有另一层意思，顶格条文作者都是用事实说话，从不论理。假如把五苓散证上吐下泻叫做霍乱，理中丸证上吐下泻也界定为霍乱，那这两个霍乱是一个病吗？要是是一个病的话，为什么治疗方剂相差很多呢？其实五苓散证和理中丸证的霍乱，症状差别还是比较大的。例如在饮食上，理中丸证首先一个症状就是不能吃东西，但五苓散证完全可以吃东西。其实两者还有很多不同，但为什么偏把它们放到一段条文中论述？原因就是想用这种方式来说明，大家都把它们叫做霍乱，但这不是一种病，这种对疾病的界定方法是不对的（仅用“霍乱”这个名称来界定是不对的）。但当王叔和把条文更改了以后，这种意思就完全抹杀了。

小结：霍乱多表现为吐利、头痛、发热、身疼痛等症状，如果同时发热多、欲饮水的，为五苓散主治之证；如果有里寒，且不用水的，为理中丸主治之证。

关于五苓散方证和一些相关问题前面学习时已讲，这里不再赘述，下面重点讲一下理中丸证。

理中丸证的病理：里虚寒证合并水实证。

下面看看方剂，理中丸由四味药物组成：人参、干姜、甘草、白

术。这些药物都是常用药，我们也都比较熟悉，其属于典型温中祛饮的方剂。方剂中的干姜、甘草、人参可以治疗因里虚寒证造成的胃肠功能低下，白术可以治疗在里虚寒证的情况下出现的里饮证。

该方证与吴茱萸汤证在病理上是完全相同的，都属于里虚寒证又有停饮。但这两个方剂之间却没有替代关系，用理中丸治不了吴茱萸汤证的头痛、头晕。经方理论的病理辨证体系从这儿就能看出来了，先通过症状反应来辨析病理状态（病理范围），然后在这种病理状态（病理范围）的基础上进一步辨别具体方剂的适应证，也就是辨方证。

另外，方子的制法和服法在经方中也算比较特殊的。先把四味药做成散，然后再用蜜和成丸，做成的丸剂还不小，有鸡子黄那么大。服的时候用开水数合研碎温服。数合现在看不到一升，然后把丸剂溶化开服用。实际上这种服法跟服散有点相似，只是做成丸后比较容易保存，其他也没有更玄妙的作用。这种服法用水量比较少，实际也是把药粉喝下去，因为没有说“去滓”，这样对呕吐是比较有利的。在其他地方有说其不如汤剂好，这得看情况，假如吐得厉害还是这个好。其实临床上直接服散也没问题。

方后注之后的内容都是后人加的，已经不止一次说过了。这里比较特殊，文字量也比较大，大概分三部分内容：第一部分从“腹中未热”至“日三服”，这可视为后人对该方后注所作的补充，可以参考。第二部分从“若脐上筑者”到“勿发揭衣被”，是方子的药物加减和服药后的注意事项。其中方剂的加减跟经方理论是相悖的，所以都不可取。这里再客观地说一下，并不是其每一味加减都没有任何道理，不是这个意思，而是在经方理论中没有这类以一个单独症状的出入而对整个方剂进行加减的概念。经方的加减不是这样，所有的经方加减之后，其方名和主治都会随之有所改变。另外，服药后的这些注意事项，我们可以做参考。第三部分是服了该方剂后，里和表未解的一个治疗方法，在《宋本》中被列为另外一条。

下面看看理中丸证的方证，症状表现最多的是食不下。这个食不下在具体案例中的纪录形式都不同。比如有的是不能食，有的是食少，有的是纳呆，有的是纳减，有的是纳差，有的是食欲减退等等；再一个症状是神疲力乏；接下来是下利；还有四肢冷，呕吐；还有腹痛、腹满、便溏、面白、面黄、胸闷、咳嗽、小便清长、虚脱、胸痛、面色无华。

舌质：以淡舌为主，还有少量的红舌、红润舌、微红舌、绛红、还有个别暗红的。

舌苔：有白苔、无苔、黄苔、少苔，最多的是白苔。

脉象：表现比较多的是沉脉、细脉、迟脉、弱脉、缓脉、微脉，另外少数还有弦脉、滑脉、浮脉、紧脉、洪脉。

有应用理中丸治疗机会的现代疾病（这里把理中丸和理中汤当作一个方剂）：慢性胃炎、萎缩性胃炎、胃石症、胃易激综合症、功能性腹泻、习惯性便秘、消化道溃疡、溃疡性结肠炎、病毒性胃肠炎、克隆病、胃炎、胃及十二指肠炎、胃及十二指肠溃疡、胃扩张、慢性结肠炎、肠伤寒、胃下垂、中毒性消化不良、肠麻痹、小儿寒性腹泻、小儿多涎（此处需注意，很多哺乳期的孩子出现口水多时，是理中汤证的机会比较多。可以看看孩子的舌质、舌苔，就比较容易确定其寒热倾向，只要是偏于寒的，不管用什么途径给药，用了以后效果都会比较好，而且孩子还会愿意吃东西）、复发性口腔溃疡、口腔炎、角膜软化症、冠心病、风心病、上消化道出血、粉刺、麻疹，戒毒后口吐清水涎沫、腹泻者，刮宫后顽固呕吐。

上述这些现代病中例如粉刺或麻疹，这些都是皮肤病，但为什么会用到治纯里证的方剂？实际上这就是以前多次强调的，经方中的里证并不是指具体的病变就仅集中在消化道内的，它只是跟消化道内的病变关系比较密切，并以那些症状反应为主要特点的一类证候。现在年轻人中的粉刺患者很多，大便不成形，吃凉东西就拉肚子，如果吃

理中汤几天就好了，但假如没有这种里寒的情况，吃半个月理中汤也不管用。所以经方的精神就是方证相应，得有这种症状才行。

另外我在整理资料时发现了两个医案，可能会启发对方剂的理解。

第一个，患者表现为上腹部隐痛、不思饮食，有时吃东西不行，腹胀、腹泻，做钡餐检查后发现胃中有个6×7厘米团块状、不规则的充盈缺损，诊断结果为胃石症，就是胃结石。医案里建议做手术，患者拒绝了。然后看中医，中医方剂是理中汤加味。一天服一剂，服了9剂后症状就消失了，钡餐透视报告胃石消失。理中汤可以治胃结石这一类的报导不多，当然这是有理中汤证，但是理中汤中可没有化石头的药。前段时间电视上报导用可乐治胃石症。而且把胃石拿出来，就在人体外面，可乐跟石头就有明显的反应过程。理中汤中的这些药都是不能化石头的，用通俗的说法人体既然有形成是石头的这种机制，当把这种机制去掉，把功能恢复了以后，人体自身就能处理，当把人体状态调整好以后，人体就会自愈。

第二个，患者平素就胃肠功能比较虚弱，在生活中也常遇到这样的病人，身体比较弱但是便秘，十天、八天甚至半月、二十天都不解一次大便，解一次非常困难。很多这样的病人用其他方子不好使，原因就是胃肠功能弱，蠕动的特别慢，中医把它叫做无力推动糟粕。凡是这种人还常要服一些泻下药，因为老便秘挺难受，有喝果导的，也有想其他办法的，由于经常服泻药，反而造成了习惯性、顽固性便秘，比较难治。本案医生就是用的理中汤，喝15剂就好了。如果碰到这一类的病，用理中汤效果也算不错。

我们从这个条文可以看出经方理论的疾病概念跟其他医学的疾病概念不同。这条论述了两种情况：一个是五苓散证的霍乱，一个是理中丸证的霍乱。虽然症状反应较为接近，但在经方理论中，它们却分别属于在两种完全不同的病理状态下发生的霍乱病。五苓散是单纯

的水证，以水证为主、表证比较轻微；而理中丸证则是里虚寒证兼轻微的里饮证，这在经方理论中实际是两种主要的疾病类型，压根就不是一种病。这就说明经方医学和其他医学对疾病的概念不同。霍乱怎么来的？不就是当时社会上流行把这类凡是出现吐泻的病都叫作霍乱嘛。那从经方理论看霍乱，把有吐泻的疾病都称之为霍乱是不对的，所以该条讲解的比较细致，让你能会用经方。

387 条：这条在《康平本》是降一字格排版的条文。在《康平本》中这段是后人加的理中丸方后加减里的一部分内容，但到了《宋本》看它论述的问题比较完整，就单独作为了一条，也就是第 387 条。

解读一下：

因为这条是理中丸方后加减中的一部分内容，所以此处的吐利自然就是指理中丸证的霍乱。由于此霍乱在吐利的同时常会伴有一些类似于表证的症状反应，所以当经过合理治疗后吐利消失，也就是霍乱好了，但有时还可能会余下一些表证的症状反应不好的情况。

另外再拓宽一点，虽然这条明确无误指的是理中丸证，但根据经方治疗原则，当表里同病里证需要温补的时候，要先温里后解表；此外还有只要有泻下或者发汗的因素，无论是表实证还是表虚证，都要用桂枝汤治疗。所以这条就是这个原则在霍乱病中的实际应用，也就是霍乱证好了，如果还余有表证，即便不出汗也没有用麻黄汤的机会，只能用桂枝汤来治疗。

小结：里虚寒性霍乱病经合理的治疗，吐利止后仍表现为体痛不休等症状的，宜用桂枝汤治疗。

吐利汗出、发热恶寒、四肢拘急、手足厥冷者、回逆汤主之、①（388）

注：《宋本》此处有四逆汤方及方后注，此从略。

胡希恕：既吐、又利、而又汗出，啊，这个厉害。这个津液，那

是，啊，顷刻就是绝灭了，啊。还有表证“发热恶寒”。“四肢拘急”，拘急者就抽了，啊。这就是这个津液、这个体液丧失太厉害了，啊。这个组织啊，失和了他就要抽。“手足厥冷”，这个胃也是虚得厉害了，啊，这个体液，啊，达不到远处了，这个血液。所以他厥冷，达不到四末了。你看这样子，他不用理中汤了，因为理中汤还有人参还有…啊，这都不行。人参这个药是微寒呐，苦而微寒呐。所以我们对于这个危急的这一种这个真正虚寒，这人参不能用了。所以人参、人参汤，啊，这后世那瞎扯，啊。真正四肢厥冷，脉微欲绝，用一个，啊，独参汤就治？那治不好的。这一个他光用四逆汤。津液是虚到家，胃也虚得也厉害了，那么这个，吐利这个汗出啊，这是脱汗呐，这就是虚脱的样子。这不赶紧的用那个，啊，四逆汤这个大力的药啊，马上这个人就…就…就…就活不了。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格排版的条文。在《宋本》条文后附有四逆汤方和方后注解，《康平本》没有。解读一下：

“吐利”指的霍乱而言，不是一般的“吐利”。

“汗出”是指人体陷于机能沉衰的阴性里虚寒证所表现出来的一种脱汗，而不是表虚证的汗出。

“发热、恶寒”是霍乱证常见的症状。

“四肢拘急，手足逆冷”是阴性里虚寒证比较重的情况下表现出的症状，同时这还有个上吐下泻的霍乱病。所以造成：一方面，人体津液随着吐利大量流失；另一方面，因为里虚致使新的水分和营养又不能正常吸收。再加上疾病来势又猛，所以很快就会致使人体肢体组织严重失养，表现为四肢抽搐，拘急，手足逆冷这类的症状。实际上五苓散证和理中丸证中近似一些表证的情况也有这方面的因素，但主要还是里证比较重，就是由于狂吐狂泻造成影响到肢体营养供应的一类情况。一般从性质上说，在这种情况下又得了表证，就是近似感冒的这种可能性比较小。

这条论述的是里虚寒性霍乱经过严重的吐下后，人体陷于阴性证；或者是人体平素就有里虚寒证的倾向，患了霍乱后迅速发展为阴性证的一种情况。这种情况就需要用四逆汤治疗，一方面温里补虚，另一方面振兴人体机能。这时人体的主要病理矛盾是：机能沉衰的阴性证和里虚寒证。虽然同时也存在津液虚的问题（狂吐狂泻使津液虚），但这时津液虚不是主要的病理矛盾，所以服了四逆汤后随着人体机能的恢复和里虚寒证的缓解，津液会自行恢复，这也是此处没有用四逆加人参汤的原因所在。人参虽然可以补虚增液，但其性略微偏寒，该方证主要是以里虚寒为主，所以就没有用人参。从这也能看出经方用药是非常严谨的。

小结：霍乱病在吐利的同时表现为汗出、发热、恶寒，四肢拘急，手足逆冷的，为四逆汤主治之证。

既吐且利、小便复利、而大汗出、下利清谷内寒外热、脉微欲绝者、回逆汤主之、（389）吐已下断、汗出而厥、四肢拘急不解、脉微欲绝者、通脉回逆加猪胆汁汤主之、（390）

甘草二两炙 干姜三两强人可四两 附子大者一枚生去皮破八片
猪胆汁半合

右四味，以水三升，煮取一升二合、去滓、内猪胆汁、分温再服、其脉即来。（注）无猪胆·以羊胆代之·

胡希恕：389条：第九，“既吐且利，小便复利，而大汗出”。这更凶，“下利清谷，内寒外热，脉微欲绝者，四逆汤主之”。这个好在他没有“手足厥逆”。这个“脉微欲绝”本来应该用通脉四逆汤。那么他没有“手足厥逆”呀，啊，这个胃气还是没到沉衰到家。用四

逆汤还行，啊。光脉微欲绝，脉微欲绝就由于这个津液丧失太厉害了。他既吐又利，小便还复利，这个丧失这个人身上体液是多方面了，这也有虚脱之象，完了还大汗出。那么里面呢？他是“完谷不化”了，啊。不但有寒，而且虚。“内寒外热”，啊。内是真寒呐，外边就是有浮火了，啊，所谓这个无根之火了，当然是也有些，啊，像上边儿一样，他也兴有发热。没有发热他大汗出，也是有热之象。其实呢，就他这个证候说，他是有热之像，实质说就是虚脱，这就是虚脱嘛。那么也只能用四逆汤。也只有那么一个方法，在其他就没有。这个比上边那个理中汤都重得不得了，啊。这要是遇着，游医…用一些这个平稳的药，治吐治利，那是绝对要送命的，绝好不了！这地方都非常的好。

390 条：这是第十条。“吐已下断”，啊，这是指着这个第九条说的，我看看呐，不是，不是，指着第八条儿，指着第八条儿说的。这是吃了四逆汤，也不吐了，也不下了。但是啊，旁的病不好，“汗出而厥，四肢拘急不解”。这一个还是不好的，啊。脉呢？反微而欲绝。这一个就得用通脉四逆汤了。这一个心脏有衰竭的现象了，啊。吃了四逆汤不是不好一点，好一些，啊，吐利都好了，但是，还是大汗出，四肢厥冷，还是抽，啊，这一个不解决。这要是，啊，拿着咱们这一个，这纯粹这是，啊，这是亡津液、亡血液这一种现象了，要是不敢用大热药，这一阵儿就不行了。只能有用这个通脉四逆汤的，啊，四逆汤这一种方法。那么他加上猪胆汁，啊，那么更起亢奋作用了。所以我们那一阵儿说这个白通加猪胆汁应该是通脉四逆加猪胆汁，我也就从这地方儿看出来的。他这个书全是这样子，要不然“吐已下断”你都看不清楚。他就是前边有讲的，他底下就有这些话。你像我们讲那一个，啊，头前儿有很多，那阳明篇里头有很多提太阳病，啊。他这个也是，啊，提上边那个四逆汤证，他说个“吐已下断，汗出而厥，四肢拘急”他搁个“不解”俩字，他这个“不解”俩字啊，

很有分量。这个不解者，说明吃药而病不解。吃什么药？他提出来了，啊，“吐已下断”以前有吐，有上吐下泻，有汗出而厥，有四肢拘急，肯定这是第八节儿的情形。所以他这个书啊，不好读就在这一点。伶俐，啊，顺口读，啊，读过了，是看不出来的。

李冠杰：这两条在《康平本》是顶格排版的条文。在《康平本》这两条是一段文字，在《宋本》中拆成了第 389 条和第 390 条。

首先要弄清《宋本》中将这段文字分成两段的原因，对照前后两部分会发现这两部分的述症是相同的，只是四逆汤证里多了“小便复利”的症状，而通脉四逆加猪胆汁汤证这部分多了“吐已下断”和“厥”，其余的述症基本相同。

这里还有个问题就是有个“四肢拘急不解”，实际上“四肢拘急不解”本身就含有前面就有这个证的意思，所以这两段条文述症是基本相同的。但从治疗方剂的变化看，两个方证中所不同的症状反应就是多了“吐已下断”和“厥”，但它们构不成方证改变的依据。而且四逆汤证这一部分明确地用了“四逆汤主之”的论述，这就很可能是后人将条文分成两条的原因所在。一个是述证特别相同，那写在同一段中就没有意思了，另一个是毕竟又有不同的地方，但这个不同又构不成变换方证的依据，所以干脆就把条文给分开了。实际上重新审视《康平本》的内容，该条文却是原文的作者少有的一种不惜笔墨而特意为之的地方。

下面解读一下，大家慢慢就清楚了。

这个加猪胆汁的方剂里还有个白通加猪胆汁方。白通加猪胆汁汤是在少阴篇第 315 条“少阴病，下利脉微者，与白通汤，利不止，厥逆无脉，干呕烦者，白通加猪胆汁汤主之”。这条论述的是少阴病同时又下利脉微，也就是表现为白通汤证，但喝了白通汤后虽然治疗方向没错，但因为人体虚极，药尽管对其症反而不能取效的情况，解决的办法就是在原方中加猪胆汁以及人尿这类的亢奋药。实际本条和第

315 条论述的是同类情况，原本是阴性里虚寒证的霍乱，服了四逆汤后症状不单单没解，反而加重了。所以这里把这条分成两段就不对了，虽然没动一个字，但对于正确理解条文就造成了挺大的误导。

下面借助于《康平本》，我们再按照今天的角度重新学一下。

“既吐且利”，指的是霍乱的吐利。

“小便复利”，实际是小便频数，这个症状出现在这条，就是由于人体机能沉衰而尤其对小便的控制能力下降所造成的。

“大汗出，下利清谷，内寒外热，脉微欲绝”，都是阴性里虚寒证典型的症状反应。“大汗出”就是脱汗；“下利清谷”是典型的里虚寒证；“内寒”是讲的病理，应该把其视为下利清谷的病理；“外热”是体温升高，这也是霍乱病发热那一类的症状；“脉微欲绝”是四逆汤类方证一个典型的脉象。

这以四逆汤来治疗，跟第 315 条以白通汤治少阴病下利属同一种情况。相同的是白通汤证用白通汤治疗但没起效，四逆汤证用四逆汤治疗也没起效。不同的是这条论述的是在一般情况下表现为上述症状的，服了四逆汤后一般是可以治愈的，但也有不愈的情况。虽然用四逆汤治疗方向不算错，但这时跟那个用白通汤的情况是一样的，人已经虚到一定程度，再单纯用四逆汤也没法让人体进入亢奋状态，所以也可能会出现不效反重的情况。因此这里仍然用了“四逆汤主之”，意思就是大部分情况下用四逆汤可以治好，但也有治不好的情况。治不好的情况就会表现下边这个样子，此时就不要再四逆汤治了，用通脉四逆加猪胆汁就行了。实际上“四逆汤主之”出现在这个地方也比较可疑。“四逆汤主之”只是其中一种论述方式，但从述症看，实际上用通脉四逆汤比四逆汤更合适一点，这是另一种情况。因此这里假如是“与四逆汤”或“与通脉四逆汤”，比用“主之”可能会更合理一些。

我记得和大家一块儿学习第 315 条时就曾经说过一次“与白通

汤”，如果治好了那就好了，就不要紧了；但是不好的就是下边的情况，实际上这里也非常类似。但这儿明显有个问题，条文下面述症特别详细，因为这是一个重症，很危险。再一个此处用了这么多重复的症状，就是想说明这些症状还在，不要以为再用四逆汤就可以治了，再用也是治不了的，应该是这样的意思。

“吐已下断”，是指服了四逆汤后吐利的症状消失了，但从后面的述症看，这种消失应该是无物可下，不是病要好的证候，而是吐利太过，病情并没有减轻。

“汗出而厥，四肢拘急不解，脉微欲绝”，是指服四逆汤之前就有这些症状，服了四逆汤仍然没解的意思。在经方里这类情况很多，凡说“不解”都有一个治疗过程，此处治疗的方法就是用四逆汤。假如前面没有服四逆汤的经历，“不解”就没法解释了。所以四逆汤证中本来就有“四肢拘急”，这里喝了四逆汤后并没有解，其他的基本上维持着原来的症状。但这里并没出现“小便频数”的述症，实际上是非常合理的，因为此时已经“吐已下断”，吐都没有东西吐了，下也没东西下了，津液虚到这种程度小便肯定也不会再频数了，这个症状也就没了。

这实际就是阴性里虚寒重症同时霍乱也没好的情况。人体已经虚极而且恢复机制也弱到极点了，这时仅凭四逆汤或通脉四逆汤已经无法振兴人体机能了。说透了还跟第 315 条白通加猪胆汁汤证是一类情况，解决的办法也是用加猪胆汁救人于危急之中。

这条由于后人的改动，致使所有后世的学者没有一个是按照我们这种角度来理解的。但通过对《康平本》的解读后，就不难发现这条中通脉四逆加猪胆汁汤证的述症跟前文四逆汤证的述症，真正有实质性差别的症状只有一个“吐已下断”。刚才分析了“四肢拘急”在四逆汤证里本来就有，但“吐已下断”也就是这种无物可吐下的情况在以前的条文中有多处论述，可没有一处是用这种方法解决的，可见这

个“吐已下断”不是加猪胆汁唯一的依据，而是前边的症状还在，服了四逆汤后不效，这才是真正在通脉四逆汤基础上加猪胆汁的依据。服了四逆汤或通脉四逆汤治不了，人已经虚了，受不了了，但还吐还下，赶紧用通脉四逆加猪胆汁，不然就治不了了。

通脉四逆加猪胆汁汤的病理：阴性里虚寒重证。

小结：既吐且利的霍乱病，同时表现为小便复利而大汗出、下利清谷，病属里寒并伴有发热，脉微欲绝的为四逆汤主治之证。若服药后吐已下断，汗出而厥，四肢拘急仍不得解，脉微欲绝的，为通脉四逆加猪胆汁汤主治之证。

下面看看方子，方剂由四味药组成：甘草、干姜、附子和猪胆汁。方剂中猪胆汁的作用和白通加猪胆汁的作用是一样，主要是用来强化附子和干姜对人体机能的振兴作用，比较简单。但到了这个情况，离了这类方子是治不了的。

下面看看方证，在临床统计资料中的数据非常少。原因是临床中这一类情况就比较少，这是其一；再加上条文经过《宋本》的调整后，对后世的误导恐怕也影响临床应用。

因此统计资料中舌象、脉象什么的就没法分了，没有那么规范，所以就把舌象、脉象都归到症状里。

症状包括：吐利过度而自止、汗出多、手足逆冷、神智昏厥或言语不清、四肢拘急、脉微欲绝，这些大概就是条文里的症状。除了神智昏厥和言语不清外，其他都跟条文的述症基本相同。

在临床中有应用机会的现代病也比较少，包括心力衰竭、心肌梗塞、休克、甲状腺及肾上腺皮质功能低下、慢性腹泻。

吐利发汗、脉平、小烦者、新虚不胜谷气故也^①、（391）

注：“新虚不胜谷气故也”《宋本》作“以新虚，不胜谷气故也”。

胡希恕：第十一条儿，“吐利发汗，脉平，小烦者，以新虚不胜

谷气故也。”“吐利发汗”者，啊，又有点吐利，而微微汗出。他这“发汗”不是，啊，咱们拿药发汗，不是的。但是虽然他有些吐利而汗出，但是脉平。脉平者说表里无…表里没什么了不起，没什么病。而且呢，这个不大烦躁，而小烦。小烦，这个烦大概都指着胃说的，胃不和则 烦嘛，小烦，里头不舒服，啊，所以他这个…啊，吐利而微微汗出。咱们讲“阳明病法多汗”嘛。这个主要的指着这个吃着了，啊，有存食，他有这一个情况，所以脉平，没有什么大…啊，其他的问题，表里上没有什么特殊的邪气，没有。这是由于什么呢？“新虚不胜谷气故也”。他得了霍乱这个病啊，那丧失人的这个…啊，所以这个胃气最虚了。那么这个胃气新虚没复，这就是瞎吃，啊，吃他就是不能消化，不能消化宿食在胃，他就小烦，啊。那么他就吐，利，这都是这么来的。那么这一个就减食就好了，我们不必怎么治疗。“所以新虚不胜谷气”。他没有克化谷气的，啊，这个能耐，啊。这个霍乱就完了，这个霍乱讲得挺好，他这个，又紧凑，啊，要点的东西都讲了。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格排版的条文。“新虚不胜谷气故也”在《宋本》加了个“以”字，“以新虚不胜谷气故也”，就加了这一个字露出了其真相。

直译：本来是以吐利为主要症状的这类疾病，经过发汗治疗后，表现为脉平而且小烦的，这是胃肠功能还没有恢复，稍有消化不良的缘故。

这条论述的不是霍乱病，实际论述的是以表证为主同时又伴有呕吐和下利的一类疾病。葛根加半夏汤方证就完全可能出现这类情况，既有呕吐又有下利。只有这类方证服了发汗药后病才有可能痊愈，真要是霍乱病，发汗还不把人发死了？那非得出医疗事故不可！但是患者本来就有吐泻，经过发汗治疗后人体应该有个恢复的过程，如果在这期间饮食过多、过量、暴饮暴食，人常会出现不适的感觉，这条实

际论述的就是这类情况，假如不是的话，怕就解释不通了。

从语韵和论述的内容分析，该条文不像出自顶格条文作者之手。这很可能和四逆加人参汤的方后注解一样是抄错了，本来可能是个降两字格排版的条文，特别又是这么一个短小的条文单独在篇章的最后，抄错的情况完全可能发生。另外这个情况在本书中也并不少见，刚才说的四逆加人参汤方后注解是这个情况，还有第 316 条玄（真）武汤方证，“玄”之前的字全是降一字格排版的，但“武汤”后面的字是顶格排版的，这就是一转行抄错了。所以这里就完全有可能也是类似的情况，特别在语言上跟顶格条文能感觉出有明显的不同。

另外条文中“新虚不胜谷气故也”在《宋本》又加了个“以”字，我们一直在强调，为什么降两字格排版的条文往里加字润色的情况比较多，因为是王叔和自己在修改自己的东西。这条中既有排版方式的问题，又有二次整理时修改的问题，这两个问题加在一块说明该条文很可能就不是一个顶格条文，就是个降两字格排版的条文，这种无病呻吟的条文。

霍乱篇小结

李冠杰：霍乱篇学完后，简单做个小结。

霍乱篇总共有条文十条，其中顶格排版条文有六条，一共五个自然段；降一字格排版条文有一条；降两字格排版条文有三条。顶格排版条文中还有一个是疑似条文，学习过程中已讲。整个霍乱篇虽然内容不多，但对于霍乱病主要的病理和相关的治疗方剂论述的都很全面。

霍乱病是一种以呕吐下利急剧发作，而且吐利的程度又非常迅猛的一类疾病。临床中如果稍有延误，就可能出现严重的不良后果，所以在这篇中对这一类疾病的不同情况都做了比较详细的论述。我们总结一下，霍乱病大致可分为五种情况：

第一种，是一般虚寒性的理中丸证；

第二种，是里虚寒证同时又陷于阴性证的四逆汤证；

第三种，是在四逆汤的基础上又存在严重津液虚损的四逆加人参汤证；

第四种，是重症里虚寒证霍乱，而且服了四逆汤不效，要用通脉四逆汤加猪胆汁汤来治的情况；

第五种，是纯粹的水证，以水证为主要病理的五苓散证。

另外还应该有个通脉四逆汤证，因为这个证在少阴篇第 317 条中已经论述了，所以在这一篇就略而未论。

因此这一篇虽然篇幅不大、论述内容也不多，但却形成了针对霍乱病各种情况的一个完整的治疗体系，从最重到最轻不同的病理状态里都包括了。

这篇还可视为是杂病的一部分。后世把《伤寒杂病论》分成《伤寒论》和《金匱要略》，《金匱》就是杂病部分。这一篇恰恰就是为杂病部分所列举的一个实例。要理解这点一定要在《康平本》的基础上再还原这篇的原始面貌后，这个作用才能凸显出来。

在这一篇里总共有三条降两字格排版条文，一条疑似条文，一条降一字格排版条文，一共是五条，总共十条条文，这里就有五条。其中降一字格排版条文实际是在方后列出来的方后加减，论述的是霍乱病病愈以后的一个余证，实际是治疗其他疾病的，不是指霍乱病。疑似条文论述的实际也不是霍乱病。而另外三条降两字格排版条文中最主要的内容和述症实际都是重复顶格排版条文的述症内容，是摘抄过去的，或者是论述的霍乱病的转归。因此除所有顶格条文之外的其他

条文，都没有针对霍乱病有实质性的论述。所以在这一篇里这部分内容应该剔除，尽管貌似论述的是霍乱病，但实际是摘抄别人的，是在搅局。

当把这五条都剔除后再来看看原文内容，就会发现这篇名为霍乱，论述的就是一个一个的方证条文，这与六病（太阳病、阳明病、少阳病等）诸篇中任何一篇的论述方式都不同，本篇没有所谓的提纲条文。假如为霍乱病总结一个提纲证条文，那太好总结了，因为太单一了，比其他六种病都好总结，恰恰就没有。这就说明在顶格条文作者的理论观点中，杂病篇的论述跟六病分篇的论述有质的不同，六病都有提纲条文，杂病只有方证条文。

但是经方理论中为什么设一个杂病篇？其实质不过是为了方便读者将经方理论与临床实践接轨所采用的一种特殊的论述方式而已。实际上它和我们今天论述经方的现代应用非常相似。比如关于肝炎病的治疗，临床统计资料显示在不同的患者身上可能用到的治疗肝炎的经方多达 60 首以上。这就说明肝炎病的概念本身就不符合经方医学的疾病概念。这个人肝炎用小柴胡汤治好了，另一个人肝炎用大柴胡汤治好了，还有一个人用半夏泻心汤治好了，另外一个人用吴茱萸汤治好了，能说这个肝炎是一种病吗？至少在经方医学中不能把它视为一种病。但为什么我们现在还要反复去论述它的现代应用，要把现代病的病名说出来？因为目前围绕肝炎这个具体的疾病进行研究和治疗的情况却是属于主流医学，无论时方还是西医，都是盯在具体的病变病位、病变器官和病变性质上，都没有真正宏观地来研究这个疾病。虽然在经方理论中肝炎并不是一种疾病，而是在多种不同的病理状态下发生的一个相同的病变，而且也不是所谓的甲肝、乙肝、丙肝这一类分型所能概括得了的，但目前的现实是以肝炎的病名来讨论相关治疗却很容易被所有人接受，无论中医还是西医一说肝炎的治疗都知道，连对患者解释时也容易接受。

实际上经方理论里所谓的杂病，就是上面讨论问题的翻版。在当时也是这种情况，所谓的杂病篇都是在这种情况下而进行分篇论述的，这一篇就是最好的说明。当把它还原成本来面目后，只剩下那五条顶格条文再加上篇头的霍乱，论述的就是霍乱病的相关治疗以及霍乱病不是一种病这么两大层意思，其他的什么都没有。

虽然这一篇论述的是霍乱病，但从病理上看里虚寒证（阴性、阳性）算一大类，水证（五苓散证）算一大类，至少有两大类性质完全不同的疾病。这本身就说明在经方理论中这根本就不是一类疾病，之所以放到一块儿论述，一方面能够方便经方的临床应用，因为在临床中症状都相似，可以便于去辨证，把这些东西都集中到一块儿来论述，便于使用；另一方面也暗示霍乱这种疾病的界定方法，根本就不符合经方的医学原理。

我们再回过头来看，这一篇经过后世注家添了一些条文，并总结出了所谓的提纲条文，然后又对一些条文进行了修改，就使得整个的条文论述结构跟六病分篇都一样了。虽然这对本篇的理解没有多么负面的影响，但却把整个经方理论和其他医学理论上的差异全部掩盖掉了。本来经方就想用这种方式让人从中体悟它对疾病的界定、对疾病的认识和其他的医学是不一样的，但这样改动后搅得人们把这些内容都淡化了。

这就是这篇小结的重点，当从这个角度再审视一下《金匱要略》的内容，有多少属于降一字格或降两字格这类的条文？例如第一篇“脏腑经络先后病脉证第一”，还有“五脏风寒积聚病脉证并治第十一”，另外就是每一篇中的“问曰”、“答曰”、“师曰”等等，一概都不是出自《伤寒论》顶格条文作者之手。另外还有一些所谓的提纲证条文，有的一眼就能看出是后人从《伤寒论》摘过去的。这里有个比较特殊的是“痉湿喝病脉证治第二”这篇，因为《伤寒论》中有，也是拿来作例子的，它是从一个相反的角度作例子：说是痉病吧？痉

病在经方理论中就属于表证，但治疗不一样，它又从另一个角度最终去要强调经方和时方的不同，和当时的其他医学不同。

这个当然是我给大家提个醒，各位还要进一步去体悟，也不一定对，这是我自己的感悟。如果按照这个思路再翻开《金匮要略》看看，大概有将近 50% 的内容的价值是打折扣的。真正需要学习的重点跟霍乱篇是一样的，就是那些方证条文。

辨阴阳易差后劳复病^①

注：《宋本》作“辨阴阳易差后劳复病脉证并治第十四”。

伤寒阴阳易之为病^①、其人身体重、小气^②、少腹里急、或引阴中拘挛、热上冲胸、头重不欲举、眼中生花、膝胫拘急者、烧裨散主之、（392）

注：

1. “伤寒阴阳易之为病”《宋本》作“伤寒阴易之为病”。
2. “小气”《宋本》作“少气”。

妇人中裯近隐处、取烧作灰、

右一味、水服方寸匕、日三服、小便即利、阴头微肿、

（注）此为愈矣·妇人病·取男子裯烧服·

胡希恕：底下这劳复易这很少了。这个劳复易呀，也不错，不过头一条儿这个药啊，这一个问题呀，我问多少人呐，我学医的时候就问，没人遭遇到这种病，啊。这一个恐怕这是，不近乎什么，不合理，看起来。他说是啊，就是得了这个伤寒，啊，就是，古人说这个伤就是热病喽。古人认为这一个大病。那么如果女的得病，啊，男女同床，这个女病，啊，就能够易到男人身上，它叫阴阳易嘛。这叫阴易，啊，由阴易到了男人身上。假设这个病在男人呢，也能易到女人身上，这是个神话，叫我看。那么这个伤寒病初愈者，这人身上带菌，可能传染这一个可能的，但是不一定由于这个，啊，男女同床。所以他这个说法啊，靠不住的，啊。我因为这个我问过很多人，讲起来都…都挺津津有味，但是谁也没遇着这个病。古人也没有，古人也就是瞎说。我看那个《千金》上也是，那个孙思邈，那说得玄天玄地的。可是这个事实我看不像有。

他这个病是怎么个病呢？其人身体重，啊，少腹里急。身上体重咱们知道啊，总是身上停湿了，肾气…伤了肾气了，啊。“少腹里急”这个少腹里急有两种问题，一种停水，小腹满，啊；一种有瘀血，小腹也满。他也没提什么，当然他这一个看这样儿是蓄水了。或者引阴中拘挛，啊，那么小腹拘挛以致于引到这个前阴，这是下边，看这样儿是虚，啊，伤了肾气，虚，停水，停湿。那么有一种虚热冲于上，“气上冲胸，头重不欲举，眼中生花，膝胫拘急者”，啊，膝胫拘急，这就说明他这个…啊，有点抽的样子，这古人就说这是毒闹的，啊。

用烧裯散，这更…更近乎怪诞，啊。这个裯呐，就是所谓中…中裯嘛，就是靠着这个，啊，内里头这个衣裤子。所以这一个现在，啊，我认为这个是怪诞不经，这个…这个事情，啊。你们看看这个，这个烧裯散，它这么个情形，取妇人中裯近阴处，煎烧灰，啊。就把这个地方啊，裤子剪下来，啊，把它烧灰存性，煎。这一味，啊，用…不是煎，啊，剪烧灰呀，是剪子的剪，我写错了。剪下来烧灰，然后啊，一方寸匕，就是，啊，现在说是，这很小分量啊，他因为这灰它是也…也轻啊，多少都没有关系。日三服，啊，用水，啊，把它冲服。小便即利。这个东西看来利小便的。他头前儿这个证候像是小便…啊，停湿停水嘛。“其人体重，少腹里急”，这看那样儿是停水。他说吃这个就利小便，啊，同时阴头微肿，此为欲愈。妇人病，取男子裯烧灰，一样。这一个，做个参考吧，啊。后来咱们根据实践再研究吧，这个东西我看不合理。我以前给他们讲的时候我也这么样子说。可是各医书上呢都提这一节儿，都提。所以张仲景这个书啊，有些地方，咱们这一个，啊，认为…这个教书的人呐，就是照…照本儿他往下传，没有的，这像这个…这个东西，就应该…应该扬弃。就像这个消渴证似的，由于这个厥阴病啊，啊，他头一节儿的提纲：消渴，气上撞心，心中疼热，有些注家呀，就是撒谎，我就遇着过这个，啊，肝消渴，还有肝消渴，嘿，嘿，嘿！他都遇着了，瞎说八道。他这个地方，也有，也有说他遇着过这个的，这都是医书上，但是活人中没看着谁遇着过这个东西。这一个咱们留待后头研究，啊，我是不敢说他是真的。传染可能，因为这个伤寒病好了，人身上带菌这肯定的，还传染，这个伤寒病传染挺厉害。

李冠杰：在《康平本》中这篇的标题是“辨阴阳易差后劳复病”，但在《宋本》被改做“辨阴阳易差后劳复病脉证并治第十四”。我们把《康平本》和《宋本》各篇章的题目做一下比较，可以发现《宋本》中所有的像某某脉证并治第几或十几，这些内容肯定是后人加的，《康

平本》中是没有的。另外从霍乱篇的标题也可以看出“辨厥阴病”这四个字应该是闲文或是后人加的，它不应该在这个地方。由此进一步延伸出《伤寒论》“辨太阳病痉湿喝”这一篇标题里的“辨太阳病”应该也跟霍乱篇“辨厥阴病”是一样性质的问题。因为痉、湿、喝本身就不全是太阳病，痉病可以认为是太阳病，但湿和喝都不是太阳病。所以这个“辨太阳病”也应该是后人加的，或者是闲文。

在这个基础上再来看看本篇的题目，我们学习的条文中只有一条是论述“阴阳易”的，而且这条还是降一字格排版的条文。由此可以推论：这篇的题目原本很可能就是“差后劳复”或是“差后劳复病”，这个“病”有没有也不一定，因为前边有一个霍乱，霍乱就没有“病”这个字。所以这篇很可能在该书最原始状态下就是“差后劳复”或者“差后劳复病”，类似这样的形式。

从这儿还可以进一步佐证《金匱要略》的标题也有相同性质的问题。当然作为一个篇章的题目未必可以影响到全部的内容，就像现在我们把这本书都叫《伤寒论》，但人人都知道《伤寒论》讲的却不仅仅是伤寒病，伤寒病只是其中的一小部分。因此以上分析至少有两层意义：一层是“正本清源”，它本来应该是什么样子，怎么发展到最后《宋本》这个样式的；另一层是可以看到经方在传承的过程中，客观存在着人为改动等方面的因素。从《康平本》就能看出这点，同样也是 398 条，但光是降两字格排版的条文就有 140 条左右，降一字格排版的条文也有 100 条左右，这些都是后人加的，原书中是没有的，这些东西有精华也有糟粕。我们通过学习《康平本》知道这是后人加的，这本身也是“正本清源”的一部分。从这个题目当中，基本可以得出这样的结论。

这条在《康平本》是降一字格排版的条文。“伤寒阴阳易之为病”在《宋本》是“阴易之为病”，这应该是笔误，肯定是把“阳”字漏掉了。但漏掉以后一直流传到今天这个字始终没有加上，说明王叔和

以后的人，特别是从《宋本》沿袭下来的对《伤寒论》的态度是非常严谨的，这里明明掉了一个字，但也没有加上。实际在原文以外王叔和整理的书中有相应的论述，此处讲的是阴阳易，所以这里肯定是掉了一个字。另外“小气”在《宋本》是“少气”，《宋本》比较确切一些。

直译：伤寒阴阳易病，表现为其人身体重、少气、少腹里急或阴中拘挛，气上冲胸、头重不欲举、眼中花、膝胫拘急的，为烧裯散主治之证。（因为这条论述的全是症状，原则上我们对古人论述的这些症状不做修整，所以这条直译也没多大意义）。

下面解读一下，由于这条论述的情况在临床中比较罕见，再加上这个疾病的诱发原因和治疗方法又比较特殊，而且其方剂放在今天临床实用价值已经不是很高了，所以对于该条文的论述只能作为一种疾病现象来研究。万变不离其宗，在实际临床中如果真遇到这类情况，应该仔细地去辨证，用方剂来治也是没问题的，关键还是要辨证准确。

从条文的论述看，这应该是一种阴性的虚弱证并伴有停饮证和血虚证的病理状态。

我们今天解读条文，正确理解条文的本意才是重点所在，有几个最基本的问题两千年来都没有人真正弄清，下面我们分析一下：

第一，这个病为什么叫“阴阳易”？这一点必须得弄清楚，历代注家相关的解释都没有太大的出入，之所以叫“阴阳易”说明与性生活有比较密切的关系。

第二，从该疾病的诱发原因和症状特征分析，其主要发于男性。因为方后注中有女性病用男性裯裆的说法，所以这一点很少有人去注意。实际看看这个病是怎么得的？得了病这些症状是什么？就应该知道这个病一般是发生在男子身上。另外女性病用男性裯裆，且不说这个方剂真正的临床效果怎么样，就说男性的内衣到底有没有这个功能？实际上男性的内衣裯裆和女性的内衣裯裆存在着质的不同。

第三，“阴阳易”这个病在历史上很多人解释成男女双方一方得了病，在快要好或在快得病时有同房的行为，然后把病传给对方。另外还有的解释，如果把病传给对方以后，最初原得病的那个患者怎么又好了，大部分人都是这么解释的。实际上很少有人去仔细想，这种解释根本不对。因为“阴阳易”这个病虽然叫“阴阳易”，貌似是男女一方得病会传给另一方，但其症状论述的非常清楚，应该跟得病之前他的性伴侣所发的那个病有所不同，假如是同一种病，就没必要用烧裯散这种奇怪的方剂来治疗了，那个人用什么方子治，他就用什么方子治就行了，这也不违反经方的治疗原则。这里用了烧裯散就是因为证不一样，在经方中证不一样就不是一种病。这一点历代的注家都没有去推敲，实际上这很重要，既然不是那个性伴侣所得的那个病，那他得的这个是什么病呢？

第四，条文中的治疗方剂在今天的生活环境已经很难再按照其要求去用了。因为要用这个方子得有几个条件：首先，内衣必须是棉纤维的织物。在当时的情况下肯定没人去穿个丝绸裤头，当时也没有这种记载，所以肯定就是棉纤维的。咱们现在很多人穿的就不是棉纤维的，恐怕这本身就不是一种物质了。其次，必须是久穿未洗的。要是昨天洗了今天穿一天，明天再把它剪来烧，大家想管用吗？因此要想这个方剂有效果，也一定得是穿了相当一段时间没有洗的。最后，没有人仔细推敲大家都简单地说，所用的裯裆是男人病了用女人的，女人病了用男人的，我个人理解应该是最初那个患者本人的贴身之物。因为按现在的理解，他（她）的分泌物应该携带相应的抗体，否则的话这个方剂就不能治病。

第五，既然得的不是他的性伴侣传染给他的那个病，那么这到底是一种什么病？按现在的理解，在过完性生活后人的抵抗力明显下降，同时其性伴侣又恰恰处在疾病的活动期（现代医学也有这个概念，在疾病初得和快要痊愈时都有一个活动期），如果是传染病的话，就

容易传染给别人。此时人的抵抗力又弱，致病因子又比较强，在这种情况下容易发生一种特殊的疾病，而不是他的性伴侣以前得的那个病。大家仔细分析条文，应该是这样一种病，实际上一般人都会有个常识，过了性生活后的抵抗力下降最明显的是男性。所以这也是上述那些论点的一个依据。

鉴于以上的分析，如今我们就把这条当成一种特殊的疾病现象，做个参考就行了。至于方剂也比较简单，在历史上都分析过很多次了，实际也没必要过多地去推敲，应用价值也不大。

大病差后、劳复者、枳实栀子汤主之、（393）

枳实三枚炙 栀子十四个擘 豉一升包绵①

注：“包绵”《宋本》作“绵裹”。

右三味、以清浆水七升、空煮取四升、内枳实栀子、煮取二升、下豉、更煮五六沸、去滓、温分再服、覆令微似汗、

（注）若有宿食者·内大黄如博棋子五六枚·服之愈·

胡希恕：第二条，“大病差后，劳复者，枳实栀子豉汤主之。若有宿食者，加大黄如博棋子大五六枚。”这个古人有这个，病之复啊，复就是重发。这个“大病差后”就指着伤寒，啊。由于不慎这个，啊，劳易，过劳他也犯。尤其这个过吃着，啊。那古人又说这个，啊，吃着了，大概吃着的时候多，也有…也有由于这个反复的，啊。所也这个，古人对这个伤寒病之后啊，男女要…要隔床的。他这个说得他“劳复者”，换言之，就不是吃着了。而“发烦热”可以用栀子豉汤主之，啊。那么有些胀满呢？加枳实。“若有宿食者”，那就是吃着了，那就所谓“食复”了，啊。这个准是大便干了，啊。可以加大黄，就是枳实栀子豉再加大黄。就是枳实栀子豉加大黄汤。他这个，这个伤寒病这个，所谓“劳复”啊，不是又得伤寒病了，不是那样子。他就是又发烧了，啊，又发烦热了，就指着这个。那么这一个呢，从这个用这

个栀子豉汤还是发烦热，啊。发烦热而大便不干，有些这一个，啊，心中懊恼啊，肚子有点满呐，那可以吃栀子豉加枳实。如果大便再干呢，就可以加大黄。他说个“博棋子五六枚”，就那围棋子啊，那么大概五六枚。这是个约略之词，我们一般…这里头用不着用那么重，啊。就搁6克就行，6克也就是…啊，要切得薄也得五六枚，嘿，6克，要是切得厚啊，两三枚就…就够了。这个病是常有的，心烦呐，摸着脑袋有点烫啊，吃点栀子豉汤，要有胀满呢，加点枳实，大便干就可以加大黄。枳实栀子豉汤，就咱们讲那个栀子豉汤又加上枳实。

“上三味，以清浆水七升，煮取四升，内枳实、栀子，煮取二升，下豉，更煮五六升，去渣，分温再服，令微似汗”你看这个书矛盾了，啊，咱们以前讲那个栀子豉汤啊，都是吐，啊，“得吐者，止后服”。在这儿它不是了。在让你吃啊，让你多盖点出点微汗就好了，他不吐了。所以这个药根本不吐。咱们以前的那个，在太阳篇讲那个吐啊，全是错的。你看这个，这个很明显，现在大家讲还是这么讲，啊，该吐的还是吐，这个不吐的他不说了，哈，哈。其实他就是不吐，那个在伤…在头前儿那个太阳篇讲的那个吐就是错的。咱们讲时候，我倒提了，我常用这个方子的，它不吐。也就是栀子豉汤，心中懊恼而烦，有些腹胀满，加枳实。那么胀满大便又不通呢，再加大黄，啊。那么在这个所谓劳复还以“食复”为多呀。以这个方子用的机会最多。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格排版的条文。我们解读一下：因为条文的论述非常简略，所以对于文字内容应推敲的细一些。

“大病差后、劳复”，这就是全部的述证，指的是患较严重的疾病初愈之后，由于劳累过度或饮食不节等方面的因素，而又出现疾病的一类情况。大家注意，虽然叫“劳复但不一定是以前的病复发，而有可能是新的疾病，这里实际上就是一种新的疾病。

“大病”，从文字上解读是指比较重的病，但在这条里还要具体一些，应该是指出现热性病的机会比较多。试想一下，如果像四逆汤

证一类的阴性里虚寒证即使是“劳复”，出现这样一个热证的机会不一定没有，但恐怕也不多。“大病差后”，一方面说明重病初愈，同时也说明此时人体还没完全恢复，处于一种比较虚弱的状态，一旦再度发病，则出现虚证的机会就比较多，这是“大病差后”的另一种含义。

“劳复”，字面意思就是因劳累过度或饮食不节而造成旧病复发，但在这条中不能这么理解，因为后面有治疗方剂。所以这里的“劳复”指的应该大病初愈后容易出现的一种虚热性疾病，而不一定是复发了以前得的病。真是复发了以前得的病，还要用以前的方子治疗。比如患者原来是大承气汤证，经过治疗刚刚痊愈后，因为不慎又发生了大承气汤证这样的里实证，大便不通，肚子也实的拒按，再生潮热的，一连串的症状出来了，用枳实栀子豉汤是治不了的。所以这个“劳复”应该客观地去理解，它是指大病以后一种比较特殊的现象。如果在“大病差后”注意不够，则容易出现这种情况。

具体该条文的方证在临床中还会有心中懊恼、心下痞满、胀痛、心烦、发热这一类的症状出现，因为有治疗方剂在后面，所以对述证方面就简略而论。我们再换个角度来理解条文，根据经方理论即使不是在大病差后又重新发病，但也出现本方证的话，也应该用这个方子来治；反过来，即使是大病差后劳复，但出现的不是枳实栀子汤证，那也没有运用这个方剂的机会。只有这样理解，才会感觉非常明了，才能对经方理论有个全面、正确的认识。

该条文的意义就在于“大病差后劳复”后，发生这个方证的机会比较多。以前是一种热证（里热证），好了以后有些余热未去，或者再有点诱因，就会以这种形式表现出来。但已经不是以前那个病了，不能说一点关系没有，但是治疗上有关疾病的本质已经变了。

枳实栀子豉汤证的病理：半表半里的虚热证合并气实证。这里叫做气实证，应该是个气滞证。

下面看一下方子，该方剂由三味药物组成：枳实、栀子和香豉，实际就是栀子豉汤的豉加量，另外又增加了一味枳实，加量香豉可以增强方剂补虚去烦热的作用；枳实可以行气消胀。栀子豉汤本身治疗的就是一种虚热证，药味经过这样变化后，就特别适合既有半表半里虚热证，虚热证又比较重，同时又存在气滞的一类疾病。

方后注解中有个比较特殊的地方，就是要求用清浆水七升，先空煮得四升后再入药煎。所谓的清浆水有两种解释：一种是用煮熟了的米饭，把米饭倒入清水中发酵到味有点酸，清水也开始呈现米汤一样的白色，但还没有形成腐败臭味的时候，这就是所谓的清浆水。另一种解释就是淘米水（俗称泔水），也是发酵到在它腐败之前的程度用。实际这两个没有质的区别，所以在方剂的煎法上比较特殊，先煮清浆水，用现在的话讲就是先消毒。其实现在临床中很少有人这么用了，大部分都直接用水，清浆水本身是寒性的，有解烦渴助消化的作用，所以对上面这几味药物作用的发挥有协助作用，其本身也算是一味药。

方后注解之后还有个附注：“若有宿食者、内大黄如博棋子五六枚、服之愈”，这应该看做是注解内容的作者临床经验所得。该方证的患者因为大病初愈，胃肠功能比较虚弱，再饮食不节就有可能发生里实证而出现大便不通，腹满这一类的症状。这种情况就和该条文的方证不一样了，这实际是一个半表半里虚热证并伴有里实证的病理状态。虽然附注轻易就说见有实证可以加大黄，但加了大黄后病理状态就变了。这一类的加减本身不能说错，但经方不是用这种方式加减的，实际上在经方的论述中这种意思已经包括了，就是教你方证相应去辨证施治，假如是大承气汤证，用大承气汤也没问题。所以说白了，这种加减还是在对经方理论理解不深不透的情况下加上的，但其本身也是经验所得，在临床中假如看到里实证的严重程度到不了这个方证合上小承气汤或大承气汤的情况时，用这个方法也可以。实际这样一加，

里面就有了多半个小承气汤，博棋子就是今天的围棋子，大黄要用围棋子这么大的五六枚量也不小，今天参照这个方法用，大黄适当减量就可以了。

下面是枳实栀子豉汤的方证：

症状：心多懊憹、心下痞满或胀痛、心烦发热、舌红苔黄、脉滑或数。因为该方剂在临床中统计到的医案比较少，所以数据就没法再细分了。

有应用该方剂机会的现代病：急慢性胃炎、慢性肝炎、急性胰腺炎、肋间神经炎。

但经方的原理在这儿摆着，只要现这个方证，具体是什么病不重要，所以这一篇中有几个方子应用的机会还是比较多的。现代的人因为过分养尊处优，体质相对较弱，出现这类方证的情况比较多，但统计到的资料比较少，我找了个医案跟大家简单一说，可能对方剂的理解就能比较深入。

有一个人夏天时患了感冒，自己用白虎汤治愈了，按医案说的这种情况，大概也是个不简单的经方医生了。但后来因为饮食不节，病又复发了，复发后表现为发热腹胀，自己又服了一些消导的药，可并不管用。他觉得又出现发热的情况，以前的病发热现在也发热，以前没有腹胀现在有腹胀，吃了消导的药不管用，再吃点白虎汤，吃点以前的方剂行不行？结果喝了白虎汤也不管用。后来症状就表现为热盛口渴舌黄便秘，就是大便也不通了，最后以枳实栀子豉汤加大黄，一剂知二剂已。

这个医案有几个关键点：第一，病复发以后跟之前的病是有出入的；第二，又服曾经治愈以前疾病的方子不效，这也很重要，虽然跟前面的病有一点关系，但已经不是那个病了。第三，服消导药也不效。说明该方剂对于这类在体质比较弱的情况下发生的疾病，比用小承气汤（此时有大便不通的情况）之类的方剂效果要好。

同时这个医案里也有一些平时读医案应该注意的地方。比如此处特别说明夏天患感冒用白虎汤，像王叔和说的白虎加人参汤天凉了以后就不能用这类的，实际上无论哪个季节得了白虎汤证用白虎汤治也没问题，该作者强调这个，实际上有意无意地就有这方面的倾向，本身是在误导别人。凡是读医案的时候，我们都得把这类因素剔除出去。

伤寒差以后、更发热、小柴胡汤主之、（394）

脉浮者、少以汗解之^①、脉沉实者、少以下解之^②、^③（394）

注：

1. “少以汗解之”《宋本》作“以汗解之”。
2. “少以下解之”《宋本》作“以下解之”。
3. 《宋本》此处有小柴胡汤方及方后注，此从略。

胡希恕：说得了伤寒病，这一个不是太阳伤寒，这个就指着伤寒病说的。好了以后，由于不善摄生，啊，或者过劳啊，这个吃最厉害，伤寒病我得过，啊，我也更发过热，也就吃的……（音频缺如）……他是饿，饿也得戒着点儿，你要吃过了他就发热。那么这一个一般小柴胡汤最好使，啊。就这个病，没有表里的明显证候，就是这个人呐，啊，手脚啊、耳面觉着发热。如果脉浮呢，这是有了外感了。那根据这个外感的情况，该用什么药你用什么药发汗。脉沉呢？啊，那是在里，这是吃着了，是吧？可以也要适应用方剂来泻下。一般泻下也都用大柴胡汤的机会多，用承气汤的机会很少。这一个，小…可见这个柴胡剂的应用范围非常的广，啊。既不关系表和里，而有发热，大概都属柴胡证，半表半里嘛，是吧？发热是阳性证，就都属于少阳病。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格排版的条文，并且是两个自然段，“小柴胡汤主之”之前是第一段，之后是第二段，在《宋本》是一条。“少以汗解之”在《宋本》是“以汗解之”；“少以下解之”在《宋本》是“以下解之”，把两个“少”字都去掉了。另外《宋本》

条文最后附有小柴胡汤方和方后注解，《康平本》没有。

解读一下：

通过对《康平本》和《宋本》条文中的差异进行分析，该条文的第二部分（“脉浮者”之后的内容）应该不属于顶格条文的内容。理由如下：

第一，《康平本》中这条本身就分作两段，但到了《宋本》却合为一段，这必是后人所为。做这样的改动，一定跟后边这个内容的写作有关，这应该是后边内容的作者本人改的，否则就没必要做这个改动。

第二，第二段两个“少”字在《宋本》中都没有了，这绝对不是笔误，不可能这么巧合，这必定是后人特意做的修改，前面对这类情况已经分析了，这必定是作者本人改的，因为后世没人做过这样的改动，《宋本》中“阴阳易”的“阳”字都还没人给添上呢。所以从这也能证明，第二段应该不是顶格条文。

第三，第二段从论述方式、论述内容以及语韵上都和顶格条文有明显的差别。所以第二段条文很可能原本就是降两字格排版的条文，但在抄写的过程中误抄为顶格的了。既然如此，我们就把这条分成两部分学习。

第一部分：“伤寒差以后，更发热，小柴胡汤主之”。这条论述虽然也非常简略，但要分析到含义本身。关于小柴胡汤的适应证以及相关的治疗原则等一些理论问题，在六病篇尤其是太阳篇中都有详尽的论述，所以这里就用了极其简略的方式进行了论述，但这并不等于所有的“伤寒差以后”又出现发热的情况都可以用小柴胡汤来治。这与上一条“大病差后劳复者”是相同的论述方式，所谓的“劳复”一定要在现“枳实栀子豉汤证”时才能适应那个方子。这也是同样的道理，“更发热”也要现“小柴胡汤证”才属于该条文论述的范畴。

这条论述的重点并不是小柴胡汤可以治发热，而是一方面说明

“伤寒差以后，更发热者”这一类情况发生小柴胡汤证的机会比较多。另一方面，说明“大病差以后”若发生小柴胡汤证，则常以“发热”为典型的症状反应。

实际临床中，我们常需采取排除法来辨证。如果患者有明显的小柴胡汤证，那就不存在这个问题了，只要没有阴证，同时又有小柴胡汤证，用小柴胡汤治就没有问题。但假如没有明显的小柴胡汤证，只是以“发热”为主要症状反应，那就应该用排除法进一步辨证。首先，不能有阴证存在；其次，不能有明显的里热证，重的里热证不行，轻微的可以；最重要的是不能有里寒证的存在，里寒证跟阴证应该是相同级别的。有一点里热证还问题不大，吃点小柴胡汤可能好不了，但也不会碍事。但是一旦有阴证或里寒证，用了小柴胡汤就有可能发生医疗事故，肯定疗效不好或者病人会很难受。

事实上整个这一篇的论述就含有这一类的意思。比如前文中的方剂就是另一类的半表半里。小柴胡汤证是半表半里虚热证，枳实栀子豉汤证也是以半表半里虚热证为主，但它是另一类的，跟小柴胡汤证不一样。这就是辨方证的问题。另外，比如后面条文中的理中丸证是典型的里虚寒证，竹叶石膏汤证是典型的里虚热证，牡蛎泽泻散是典型的水证。我们完全可以举一反三，凡有小柴胡汤证之外的其他类型疾病时，就需要进一步按照经方理论来辨证施治。这里再重复讲一下，假如患者同样是在大病（比如重的“伤寒”）后刚痊愈又出现“发热”的情况，如果是现枳实栀子豉汤证的话，那得用这个方剂治，不能用小柴胡汤。推而广之，假如要现其他方证，比如现小承气汤证得用小承气汤治，也不能用小柴胡汤。这就是经方治病的道理。

小柴胡汤证中出现发热的机会很多，比如第 99 条“身热恶风”；第 104 条“日晡所发潮热”；第 229 条“发潮热”；第 232 条“有潮热”；第 379 条“呕而发热”，这些都是小柴胡汤的治疗范畴。正因为这样，后世的注家就把小柴胡汤总结成是一个退热的良方，直到现

在还常有人这么说。这实际就是典型地、片面地理解经方理论的一种倾向。大家试想，理中汤证的发热，四逆汤证的发热，通脉四逆汤证的发热都要用小柴胡汤来治，那能治得了么？不但治不了，还有可能出医疗事故，比如通脉四逆汤证出现的发热，用了小柴胡汤就有可能死人的！所以凡是这种某方剂可以治疗某一种病、或某一个具体症状的说法，都是与经方理论相悖的！

我们今天分析的都是一些比较深层次的东西。好多地方都说小柴胡汤可以去热，看似是有道理，但要把它说成是退热方就错了。经方辨证施治的原则是方要与方剂的适应证相对应，并且每一个方剂的适应证都不是一个孤立的症状，也不是一个具体的疾病。经方理论对疾病的概念和其他医学对疾病的概念是不同的。小柴胡汤在有小柴胡汤证的情况下有很好的退热功效，但是要说小柴胡汤是退热的方剂，问题的性质就变了。这一类的“真儿”大家一定要“较”，一定要较真儿，否则会直接影响临床应用。在临床应用辨证中稍微思想一活动，就从这个方剂跳到那个方剂去了，就是一个“治愈”和“治坏”的问题，这都是方向性的东西。

大病差后、从腰以下、有水气者、牡蛎泽泻散主之、（395）

牡蛎^熬 泽泻 蜀漆^{暖水洗去腥①} 葶苈子^熬 商陆根^熬 海藻^② 括萎根各等分

注：

1. “去腥”《宋本》作“去腥”。
2. 《宋本》此处有“洗，去咸”三字。

右七味、异捣、下筛为散、更于臼中治之、白饮和、服方寸匕、日三服、小便利、止后服、

胡希恕：这个也是常见的，啊。这个《金匱要略》有，他说这个

水气病就是浮肿了。要在腰以下肿利小便，腰以上肿可发汗。我们在门诊上就有一个，一个小姑娘，她…她就是眼睛肿，我是给他吃得越婢汤，她现在还挺好。所以要是身腰以下肿呢，啊，那就利小便。他随着这个部位呀，他这东西，他也有关系呀。要是腰以下肿啊，总是在…由于这个，啊，下焦的这个小便不利的关系，所以他利小便就好了。这一个“大病差后”啊，这个事情很多。他又由于这一个，啊，这个代谢也没恢复正常，啊，他有的时候，啊，他这吸收上不好啊，或者是这个，啊，小便有些不…排泄呀，不够，啊，有时候停饮，有时候有浮肿。那么在腰以下的可以用利尿药。这个方子就是普通的利尿药。他这个在栝蒌和牡蛎，这栝蒌根牡蛎散，这也是《金匱要略》的方子。这个它是一个，啊，滋阴解热的。那么这个大病差后，他由于这个，有…有这个水肿啊他也有烦热。肯定用…看这个方子是这个样子，他用的栝蒌牡蛎嘛。其他这四味药都是祛水利尿。泽泻咱们知道了，蜀漆也是，这个蜀漆要大量用他是要吐的，啊。所以他要洗去腥，啊。那么葶苈子、商陆根这都是祛水的，海藻。但是他这个药用得呀，挺厉害，啊。你像商陆根呐，和这个蜀漆呀，都多少有毒。所以我们要用呢，要我看呢，用五苓散比这个都强。他如果有，啊，烦渴的情形，栝蒌、牡蛎可以用。其他我用这个，根据这种情况，用五苓散呐，或者用那个防己茯苓这一种法子都行的，啊。他也随便举个例子，这一个只说个利小便，他举这么个例子，啊。这个是…什么利小便？你根据情形看吧，啊，他由于小便不利下身肿，你根据情形啊，用利小便的药物，就可以的。不一定限制于这一个方子。这一个方子，啊，很厉害，啊，尤其蜀漆那个药用不好了，他吐。葶苈子没问题的，葶苈子它…它祛上边水的。如果有浮肿，有些咳嗽，痰多，这葶苈子可以用，啊。往旁的利尿药加也行啊。这个商陆根治水肿是挺有力量个药，啊。但是我们用商陆根呢，也可以用木防己，木防己那药挺好，它没有毛病。所以这个方子啊，也是举…举一个例子而已，这不一定

非用它不可。所以这一个方子呢，去这个水肿力量，相当有力量。同时呢，有些烦渴的样子，所以他用栝蒌、牡蛎配合这四个祛水利尿的药。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格排版的条文。

解读一下：

这条论述的是大病初愈后容易发生水证的一种情况。大病初愈，一般人体都处于比较虚弱的状态，所以这里的重点是要强调不应该理解为仅限于“大病差后”，实际上这就暗示了该方剂的一个很重要的病理要素就是“虚证”。其实本篇其他一些条文也都有这方面的特点，之所以放在“大病差后”这个条件下论述，大部分都是处于虚证的状态。“大病差后”有时也会出现实证，但在别的地方论述了，这里没有。

“从腰以下有水气”，就是下肢水肿。这应该理解是该方证的一个典型症状反应，但不是唯一的。方剂中所用的药物基本都是寒性的，说明其适应证中必有明显的热性证。另外栝蒌根、牡蛎这类药还有一定的补益和强壮作用，说明该方证同时又有虚证。此外方剂里还集中了很多祛水的药。综上所述，该方剂的主要病理是：在里虚热证的情况下，以水实证（停饮证）为主的一种疾病。

只要符合以上分析的病理，就有用该方剂的机会。从实际临床资料看，除浮肿这个症状外，还常伴有腹胀，小便不利，口渴等这一类症状。从方剂的现代应用看，有应用机会的现代病都是一些比较重的慢性病，从这儿也能佐证牡蛎泽泻汤证的病理就是里虚热证合并水实证。

下面看看方剂，方子由七味药组成：牡蛎、泽泻、蜀漆、葶苈子、商陆根、海藻和栝蒌根各等份。牡蛎、栝蒌根都是寒性的补益药；泽泻、蜀漆、葶苈子、海藻、商陆根也都是寒性的，同时又都是祛水的药物。所以这是一个解热、祛水，同时又有强壮作用的方剂。

需要说明的是，上述这些祛水药中大概有二、三味在《药典》的记载都是“性平”，《药典》中说的“性”不是指寒热属性，而是指“性味”的“性”，所以都说是平。但实际它们都解热祛饮，所以应该是寒性的。中药里有很多这样的情况，所以根据我个人的感悟，药物的寒热属性是比较重要的，临床用药时一定要对药物的寒热属性有所了解。

在该方剂的祛水药中泽泻在以前的方剂中出现过，应用频率比较高，是个常用药。除了这味药以外，其他几味药在经方中应用频率相对不是很高，所以就有必要对这些药物的作用进行进一步分析，仔细分析后会发现该方剂在上述那些作用的同时还另有其他的作用。因为这些祛水药都是寒性的，在解热祛水的同时，蜀漆有消除腹中癥结的作用；海藻可散结化痰、解凝；葶苈子可以消积；商陆根可以消坚通塞；牡蛎也有散结的作用。因此该方剂中的药物有半数以上都有消除瘀结积聚的功能，所以它还是个行瘀非常强的方剂。在临床中该方剂治疗的有肝硬化腹水这类的疾病，这就是道理所在，所以不应该把它单纯看作是一个解热祛水的方剂。

牡蛎泽泻散的方证：

症状：浮肿、腹胀、小便不利、口渴。

舌质：红舌、淡舌、紫舌。

舌苔：腻苔、黄苔、白苔、滑苔。

脉象：沉脉、弦脉、数脉、滑脉。

有应用机会的现代病：肝硬化腹水、肾小球肾炎、肾盂肾炎、膀胱炎、粘液性水肿、胸膜炎积水、腹膜炎积水、心源性水肿。

大病差后、喜唾、久不了了、胸上有寒·当以丸药温之·宜理中丸、①（396）

注：《宋本》此处有理中丸方及方后注，此从略。

胡希恕：这一个是没问题的，啊。这个“大病差后”，这胃气不复。就是胃虚有寒，啊，尤其有寒饮。这个胃虚才停饮呢，胃要不虚，这饮在这儿待不住。他由于有饮，所以他“喜唾”，这个饮往上，啊。这根据我们辨…这是根据辨证这都挺好啊。口干口渴，里头都有热。喜唾，啊，这口当然不干了，是吧？口水多，都是里头有寒。那么有寒怎么样子呢？就用温药嘛，啊。一般最常用的就是理中。理中者理中焦，就是治胃。啊…这古人说是治脾了，脾胃，是吧？那么究其实是脾，古人说那脾那个功能啊，大部是胃的功能。不过我们也可以加这么个小心，也有的时候是吴茱萸汤证。吴茱萸汤证啊，也喜唾。但是他那个喜唾呢，他胃的毛病较比重，啊，总是要有恶心，起码是恶心，啊。甚至于他头要晕。那个胃停水多，那就是吴茱萸汤证。也有唾涎沫而头痛，或者头晕，或者有胃疼，啊。那个都是…也是温中去饮，那个去饮的力量大了。它影响到头部。这个理中汤不影响头部，但是心下痞硬，他胃特别虚。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格排版的条文。《宋本》在条文之后有理中丸方及方后注解，《康平本》没有。

下面解读一下：

这条论述的是一种在大病初愈后发生里虚寒证的情况。

“喜唾、久不了了”，指的是口水比较多以至于不得不时时吐涎水，这是由于胃虚的同时又发生里寒证所致。因为胃功能低下，所以造成胃中停饮。一般情况下，胃中有停饮往往表现为口中和，如果停饮严重水就会上逆，实际就是胃中停水多了从口腔里表现的程度也会严重。实际临床中比如儿童的口水多、流哈喇子的那种，凡是属于里虚寒性的，用该方剂的机会就比较多。

吴茱萸汤证跟该方证病理相同，另外有时也会出现吐涎沫的症状，吐涎沫的病理机制也是一样的，但两个方剂只是在这一点比较相似，其他差异还是比较明显的。理中丸证没有头痛、头晕这类的症状

反应，胃部的不适程度往往也不如吴茱萸汤证重，吴茱萸汤证是烦躁欲死，很难受。

伤寒解后、虚羸少气、逆欲吐^①、竹叶石膏汤主之、（397）

注：“逆欲吐”《宋本》作“气逆欲吐”。

竹叶二把 石膏一斤 半夏半升洗 麦门冬一升去心 人
参二两 甘草二两炙 粳米半升^①

注：“粳米半升”《宋本》作“粳米半斤”。

右七味、以水一斗、煮取六升、去滓、内粳米、煮米熟、
汤成去米、温服一升、日三服、

胡希恕：这是一个很要紧的方子，啊。伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐者，竹叶石膏汤主之。这个伤寒这个大病是解了，但人不爱恢复，人不爱恢复主要还在胃呀，啊。人也虚，也瘦，那么感觉气不足，气短。而且老要欲吐，“气逆欲吐”。那么古人说是“壮火食气”呀，这个“气短”总是与热有关系，啊。这个热能够伤人气，这个《内经》上的话，壮火食气，气食少火，是吧？这个胃呀，喜温不喜寒。所以呀，胃平时得温，才能够，啊，所以“少火食气”呀，但是不要温大劲儿了，要是热大发了反倒食气，就短气了。从这个少气上说，这里头有热象。那么气逆欲吐呢，这是胃不好。当然胃虚，我们现在的的话就是胃阴虚了，是吧？嘿。他就是胃虚有热，那么竹叶石膏汤这是个好药啊。这个方子它由麦门冬汤来的，他又另外加石膏。这个竹叶、半夏都是下气的药，下气止逆，啊。所以这个竹叶也治咳逆，半夏治呕逆嘛，它是下气止逆的嘛。那么另外呢，人参、甘草、粳米、麦门冬都是健胃的。不过麦门冬这个健胃呀，啊，它是健胃生津，它是甘寒。我们胃要是真正虚而热可用，胃虚而有寒是万不可用的，啊。人参这个药它是一个平稳药，它微寒呐，寒热都可以用。唯独麦门冬，

啊，那不能用的。尤其石膏更不行了，那是…啊，专祛热了。这个主要是，胃既虚而又热，那么才有这个虚羸少气，啊，啊…咳逆，啊，这个气逆。这个气逆呀，多种呀，一方面咳嗽也有了，呕逆也有了，啊，欲吐。那么这个竹叶石膏汤这个药啊，所以我们对于这一个，一般的这肺结核啊，它挺好，在末期的时挺有效。啊…但是在初期时候用石膏的机会还是少的。这个药很好。我们一般治这一个，啊…人，啊，就是胃虚有热呀，啊…咳逆呕逆呀，这个方子都挺好使。这在大病差后啊，啊，这个虚热老是不断，老有。那么发生“虚羸少气，气逆欲吐”那一种情况，那么可用这个方子。这个方子你们看看，半夏、人参、甘草、粳米、麦门冬，这就是麦门冬汤。麦门冬它治这个火逆上气，咽喉不利嘛，就治咳嗽。咱们说是这个，啊，“清阴养肺”就是这一个，就是这一…这一个情……这一个办法。另外呢，它加上竹叶、石膏了，它祛热下气的力量更大了。这一个方子最常用了。

李冠杰：这条在《康平本》是顶格排版的条文，“逆欲吐”在《宋本》是“气逆欲吐”，《宋本》应该是对的。

解读一下：

这条论述的是伤寒解了以后，也相当于大病初愈，人体却处于里虚热证的病理状态下而容易发作的一种疾病。虽然在实际临床中的多数情况下，该方证并不是真正在伤寒解以后才会发生，但作为病因在条文中可以说明：患伤寒病或其他较重的疾病全愈后，里热没有除尽则容易发生竹叶石膏汤证。同时在里虚热证的病理状态下，发生该方证的机会也比较多，纯粹里虚热证出现竹叶石膏汤证的机会比较多。

“虚羸”是人体大病初愈后的一种身体状态；“少气”是患者因为体力不足并且感觉有短气的一种反应。“虚羸少气”放在一起就是人的身体比较虚弱，甚至处于消瘦、身倦、乏力、短气的一种状态。“少气”既有受里热因素的影响，也有体虚的因素。

“逆欲吐”在《宋本》是“气逆欲吐”，从两个版本比较《康平

本》应该是漏抄了一个“气”字。再看看《金匱要略》里的麦门冬汤也是“火逆上气”，所以这里应该有个“气”字。这就是由于胃功能低下，也就是胃虚，不单是消化能力不足，同时胃气也不得下行而造成干呕、欲吐这一类的现象。

竹叶石膏汤证的病理：里虚热证兼气实证，这有一定的气实证，但气实的因素不是很重。

因为条文的论述比较简略，所以对于竹叶石膏汤证的症状反应还有必要结合方证的病理和实际临床统计资料进行一个补充：

从临床应用看该方证因为有明显的里热证，所以常表现为发热、口渴喜饮、烦躁、小便黄赤、脉数、舌红苔黄等症状；因为有里虚证，方证中也可常见虚羸倦怠、呕吐、脉细这类的症状；因为有津液虚的因素存在，如口渴喜饮、口干唇燥、苔腻少津这类的症状也常出现；因为有气滞的问题，所以方证中还可能会出现呃逆（打嗝）的情况。

我们看看方子，竹叶石膏汤由七味药组成：竹叶、石膏、半夏、麦冬、人参、甘草、粳米。方子就近乎麦门冬汤去掉大枣加了石膏，麦门冬汤中麦门冬的用量非常大，但这里药物的比例相差很远，麦门冬没有那么大的量。麦门冬汤是《金匱要略》里的方子，治的是火逆上气、咽喉不利这类的情况，实际就是津液虚，而且是虚热的情况。该方剂中的麦门冬是个寒性药，有清热滋润的功效，可以养胃生津、润肺止咳、清心除烦，同时也有一定的强壮和补益作用。竹叶也是一味寒性药，能解热、止咳、下气，在该方剂中就有下气的作用；半夏在方剂中主要也是止呕下气；所以竹叶和半夏都有降胃气的作用。人参、甘草、粳米可以安中生津、补虚；石膏可以清热。所以本方剂既能清热，又可补虚生津，还可降气逆，在临床中是个常用方剂。

竹叶石膏汤证的方证：

症状：发热、口渴喜饮、虚羸倦怠、不欲饮食、口干舌燥、烦躁、呃逆、呕吐、小便黄赤。

舌质：舌红、舌红绀少津、舌绛无津、舌边尖红、舌黑。

舌苔：苔黄欠润、少苔、苔白、黄腻苔、黑燥苔、苔浊，另外还有苔白腻、苔灰褐、苔白滑、苔多少津这一类出现的频率比较低。

脉象：细数脉、数脉、虚数脉、洪数脉、滑数脉，数脉出现的几率比较高。

因为该方剂是常用方，所以有应用竹叶石膏汤机会的现代疾病比较多，统计到的有：大叶性肺炎、病毒性肺炎、麻疹合并肺炎、急性咽炎、无名低热、慢性胃炎、肺结核低烧、糖尿病、慢性支气管炎、慢性支气管扩张咳血、急性黄疸型肝炎、流行性脑炎、慢性肾炎、神经性呕吐、金黄色葡萄球菌败血症、中毒性心肌炎、脑脊髓神经炎、蛛网膜下腔出血、乙型脑炎、脑震荡症、小儿夏季热、小儿中毒性消化不良脱水等症、小儿消渴病、小儿夏季厌食、肠伤寒、癌症发热、癌症术后虚烦内热（这不是西医病名，但应该对我们有用）、原发性肝癌发热、肝癌介入化疗后呕吐、防止防治恶性骨肿瘤化疗后副作用副反应、因肺癌或者肺部肿瘤放疗后造成放射性肺炎、红斑性狼疮、特发性血小板减少性紫癜、流行性出血热、热射病、多梦噩梦、流感、呃逆、牙疼、复发性口腔溃疡、口腔炎、角膜炎、结膜炎、巩膜炎。以上能看出竹叶石膏汤在临床中对虚热证的应用范围还是比较宽的。

病人脉已解、而日暮微烦、以病新差、人强与谷、脾胃气尚弱、不能消谷、故令微烦、损谷则愈、（398）

胡希恕：这是最后了，啊，告诉人这个，这个护理这是最要紧。尤其是这个大病这个将好，脉是…啊，是如平啊，没有什么大问题了，可是呢，日暮微烦。就是“日晡所”了，“日晡所发烦热”，这是属胃，啊，属阳明嘛。这个日降暮的时候微微有点烦，不是大烦，啊。虽然胃有些问题，不是个大病。这是什么道理呢？就是这病新好啊，哎，“人强与谷”。这是咱们这一个，旧日有这个陋习呀，人有了病

了，尤其爹妈，很怕饿着，啊，又给做这个吃那个吃，多吃点儿，好强壮。这才坑人呢！嘿，嘿！就吃出病来了。这由于这个大病差后，这个脾胃气呀，一半时不恢复，还在弱的时候呢，它不能够杀谷。所以，他这停食了他就微烦。“损谷者愈”，少吃就好了，啊。他没什么病嘛，他就只是微烦，而脉如平，这就是，不要那么吃就行了。这个很有教育意义，啊。所以咱们这个，尤其这个老人疼儿女，是有这个…有犯这个毛病，啊，见着病不能吃了，老劝他吃，这个是…不是好事儿，啊。咱们到这儿算讲完了。讲完了，这两…这两章都好懂，啊，这个霍乱呐，和这个劳复易呀，啊…这他附在伤寒之后了，啊，他也是这一个，因为与伤寒也有关系，尤其这个霍乱。

李冠杰：这条在《康平本》是降两字格排版的条文。

直译：患者的脉已近于平脉，但每天傍晚出现微烦的症状，这是由于疾病刚刚痊愈，患者摄入过量的食物，而此时人体的胃功能还比较虚弱，消化能力尚未完全恢复，所以出现微烦的症状。这种情况减少食物的摄入量即可痊愈。

这条论述的实际是大病初愈后在护理方面应该注意的常见事项。凡是人得了大病刚痊愈后，最常见的表现就是食欲改善，愿意吃东西了，但这时胃肠功能还没完全恢复，所以在饮食方面一般要特别注意，不可多食，否则就会出现消化不良以及类似条文中论述的状况。“病人脉已解”应直接理解为大病痊愈后，这种“脉已解”的说法不对，但该作者特别重视脉诊，所以就在无原则的拔高脉诊。实际在《金匱要略》的论述中，有时候脉平也代表有病，这种说法比较客观。这里说的脉解了，病就好了很不客观。

阴阳易瘥后劳复篇小结

李冠杰：这篇中共有七个条文，其中顶格排版条文有五条，五条中还有半条是可疑的，降一字格排版条文一条，降两字格排版条文一条。这篇条文虽然不多，但针对大病初愈后容易发生的几种典型病理状态和方证都做了比较具体的论述，并给出了相应的治疗方剂，其中的五个方证各有各的病理，这里就不再重复了。

这一篇论述的典型方证，实际是以这些方证为例，一方面阐明人体在处于较为虚弱的状态下容易发生的疾病类型，并从中蕴含了人体生理、病理和疾病的发展规律（涉及到大病瘥后、伤寒瘥后）。治疗方面，有的就是常用方，如小柴胡汤。伤寒瘥后就是因为人虚后容易得虚证，这里就涉及了人的生理、病理以及疾病的发生、发展、变化的规律。另一方面，条文以大病瘥后这种特殊的病因示人，告诉人们经方辨证施治的内涵：虽然论述的都是一些发生在大病初愈后的情况，但在不同的患者身上却可能表现出完全不同的疾病类型，比如理中丸证和竹叶石膏汤证在寒热属性上就是 180 度的大相反。所以虽然都是大病刚好人体陷于虚证，但在不同的人身上出现的疾病类型不一样。因此最终的治疗还要遵循经方方证相应的原则，再具体进行辨证施治。

另外，这种有相同因素的不同方证都集中在同一篇进行论述的方式还有个作用，可以为经方实际临床应用提供一定的便利。例如医者手上假如真有大病瘥后或体质非常虚弱的病人，就会立刻想到这一篇中论述的这些方证，如果不符合，就再根据这个思路也会想到其他以虚证为主要病理特征的那些方证。这就是为了接近临床，站在这个角度再看《金匱要略》中的杂病，实际与这一篇是相同的意思，都有这样的作用在。为什么六经辨证里不管脏腑，但到了《金匱要略》又出

了一大堆脏腑？因为杂病看似用脏腑分类，其实都不是同一种病，病理因素各不相同，涉及到各种不同的方证。

到此为止，我们就把整部《伤寒论》学完了，随着时间的推移这次学习的价值就会逐渐显露出来，因为很多东西是在学习过程中做的一些独到的心得探索。对错与否不重要，我们有根有据地做了一些新的探索，我们的宗旨就是为了正本清源，最大限度还原经方的本来面目。

注：此处宋有以下诸篇，康平本无。

《辨不可发汗病脉证并治第十五》

《辨可发汗脉证并治第十六》

《辨发汗后病脉证并治第十七》

《辨不可吐第十八》

《辨可吐第十九》

《辨不可下病脉证并治第二十》

《辨可下病脉证并治第二十一》

《辨发汗吐下后病脉证并治第二十二》

《伤寒论后序》

《附〈伤寒论〉子目》

《宋本》无以下文字内容。

凡疗治之方有奇恒之理奥毒药之化机又经旨之所秘多
传方文字传法□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□中之学先讲家传之
论说而后可令逅四部之教习□也

康平三年二月十七日

侍医丹波雅忠

贞和二年十二月十五日以家秘说授典药权助毕

和气朝臣嗣成

南山隐士山秋五徂谨书

附：方证辨证论（方证的内函）

胡希恕：这就是我研究这个《伤寒论》呐，《伤寒论》它是…张仲景他是…他这个辨证的体系呀，就我写那引言，他是讲六经八纲，最后辨方证。这个方证在张仲景这个辨证啊，就是一个最重要、最具体，啊，最末的这么一个阶段。那么解释这个方证，什么叫方证？这是简单的话了。方证就是方剂的适应证。适应证，啊，方剂的适证就是…这两个字。那么什么方剂的适应证呢，就叫什么方证。在张仲景这个书里头他也曾经提过。他不强调这么…这么，他那个意思是这个意思。但是看这个书的人都把它忽略了。你像那个…他常提的是桂枝汤证啊，啊，柴胡汤证啊，白虎汤证，承气汤证。这都在这个《伤寒论》里头提过的，《金匱要略》也提过。那么，可是读这个书啊，大家在这个上他不注意，注意的人呐，首先是陈修园。《陈修园七十二种》你们可以看一看。陈修园他说是啊，这一个，他就这么提的，他说是桂枝汤证，柴胡汤证，白虎汤证，这是仲景书里头一个最大眼目，最大着眼处了，啊。也就像我说的这一个，他是最重要、最具体，辨证到最具体了，最末的一个阶段。也就是，我以前用那个简单的话，咱们那个…那个引言里头也有嘛，我说他是辨证的尖端。他这个尖端呐，他就内…就是这个逻辑讲这个，啊，内包外延的关系。这个内包越具体了，这个外延越小了，是吧？你比方说吧，咱们说动物，脊椎动物，又沿着一种这个人类，是吧？这是…那么那一个，所以你光说个动物，那什么，那那多去了。你要说到脊椎动物呢？他在动…他这个…啊，又是缩小他这个…啊…内包，所以外延呢，也就是小了。你要说到人，那只是两条腿的人了，能说话。那么他这个辨证也是，开始是大面积的，啊。他是一个，你像拿这个，咱们说这六经吧，就是表里阴阳。就是每一个病位都要反应这么两类证候的，这是肯定的。

这我说这一个是千真万确，但是从…从有他这个书到现在没有这么讲的。这就是六个类型。这现在临床上还这六个类型。你像太阳病吧，咱们常见着。太阳病也就这么两…两…两个，一个中风，一个伤寒，这么两个类型。那么这就是，啊。所以他这个六经辨证，再分析八纲。这张仲景的辨证的这么一个程序，体系，啊。最后了，光辨这还不行，得辨方证。那么，那个方证，这是很重要一个事情，啊。那么一个大夫，尽管他对于这个辨证论治的这种体系，啊，理论他什么也不知道，但是就对于方剂他心里有个数。这是什么呢？就是方证。就是这个方剂的适应证，他心里有数，他就会运用这个方剂治病的。这很多了。这个乡间的秘方就是如此了。他对这个方子啊，那个王老太太也是啊，那个中医医院那个王老太太，他专用那种坐药治这个妇科，那治得真好。可是她一看这个病啊，哎！她说这个药行，你准行。说是这个药不能治，你这个病我不能治，就是对她那个，啊，对他那个那个方证不适应。这是很重要，很重要的，所以这个它是一个辨证的尖端。要读张仲景这个书啊，要不知道方证那是根本就不行。所以他这个方证并不多呀，连《伤寒》带《金匱》就二百多呀。那常用的东西。可是这里头挺复杂，我这一回就把它做一个经方方证类解。我写这个东西呀，头前儿，你看看这儿就有了。这不开始嘛，那么我这一个，头前儿这个序言就是我说这些了，那么开始就是桂枝汤类，啊。因为这个在表证，他有两大方，两大系列的方类。他为什么？就从中风、伤寒上起的。一个他是要用桂枝汤法，就是自汗出这一类的；一个他要用麻黄汤法。那么随着这个证候的出入，那这个方剂就得改。所以这个方证这最…最具体了，啊。他要讲这个，那么桂枝汤形成一大系列的方剂；麻黄汤类呢，也形成一大系列的方剂。所以对于太阳病、少阴病的研究也就只是这个，就是发汗剂。发汗剂有这么两个。你像这桂枝汤我写完了。写完了，我这一回呀，不像以前，这一回我把方证特别后头强调一下子。这就是桂枝汤证探讨最后是这样子。基于以上论

述可见桂枝汤为一太阳病的发汗解热剂，从这个方剂这个性质它是这样子，发汗解热。但以药味偏于甘温，这是拿这个抽象的来…来说这个方剂了。他这净用甜药，温性药，而有益…啊，而有益胃滋液的作用。他能够啊，啊，对于这个胃有好处，啊。就是咱们说这个能够培补中气了。那么它有个滋液的作用，就是生津液。所以他的应用益于津液不足的表虚证，津液不足。所以这个桂枝这个大家的认识他就是有…有些问题了，我这个因为…啊，这是根据实际情况。要体液充盈的表实证，或者有里热，里不但不需要补益，而且还有热。你像“酒客不可与桂枝汤”就是这个东西，啊。不可与之。有关具体的适应证可归纳为以下几点。这就根据仲景的说…说这个。那么什么桂枝…桂枝汤汤证究竟实是什么呢？就在这些情形之下：太阳病发热汗出、恶风而脉动浮弱者；二病常自汗出，或时发热汗出者。他都得损失津液。头一个，啊，也是…发热他都发热，他桂枝汤解热，都汗出，所以脉也弱，啊，脉虽浮而弱，所以脉迟啊，脉弱呀，脉浮而虚呀。这都可以，这都是说明这个…这个…这个…这个身上这个体液它亏损嘛。病常自汗出或时发热汗出者。发汗或下之”，发汗或下之都是伤人津液呀，那么这个表未解，那你肯定还得用桂枝汤，麻黄汤不能用。“阳明病脉迟”，阳明病脉迟它是不及的脉。脉迟啊，在张仲景这个书“尺中迟者”谓之…就是津虚血少。那么虽汗出多，汗出多就像“阳明病法多汗”那个情形似的，但是而“微恶寒者，表未解者”，这表未解，这一个解这个表，从那个脉迟，汗多，他这个津液丧失更厉害了，也得用桂枝汤，啊。“病下利而脉浮弱者”这一个他本来他是一个太阴病脉浮者。嗯，你看那个太阴病我都讲过了，可…可发汗宜桂枝汤，这一个都是王叔和给搞的，这都不对了，他那个本文啊，根本是对的。他那个太阴病脉浮啊，这一个“太阴病脉浮”指着下利说的，就是下利证，下利证脉浮，有用葛根汤的机会，也有用桂枝汤的机会，跟那个旁的发汗法子一样，他得脉浮。“脉浮”这说明是表证，就是表里

并病。表里并病它是一个阳性证，当然得先解表。所以在葛根汤呢？他这个书上写的“太阳阳明合病”；那么在这一块儿地方呢，桂枝汤呢？他又写一个“太阴病脉浮者”。他这个，所以这个，大家注家，就说太阴病也有表证了，啊，不是，他指着下利说的。为什么这一个他写个太阴病，那一个写个阳明病呢，太阳阳明合病呢？他就是病有虚实的关系。他这个脉它准是浮弱，他如果这个脉要是浮紧，他也用葛根汤，啊。或者有汗出等等的，这玩艺儿，这个…读古人书啊，死于句下不行。他这个这个书年久了，这个经过王叔和的编次啊，我认为有很多的问题，啊。再就是“霍乱吐利止”。上吐下泻损人的津液更凶了。那么这一个他表还没解，而身痛不休者也可以用“稍与桂枝汤”。这都不能够用其它的发汗法子。那么这几项都在这个特殊情形之下，就他的具体的适应证。这一个，你像…那个研究中医呀，有一些问题呀，这一个…你像拿这个桂枝加桂汤，这一个我也写了。这个仲景呢，他这个就这么一节儿，所以这也值得讨论的。“烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚，气从少腹上冲心者，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤”。这个奔豚是一个，你看看，我这个注解，我这回注得较比用点心。《金匱要略》曰，“师曰：奔豚病，从少腹起，上冲咽喉，发作欲死”。要是不发作，“复还止”，那就是好人一样。那么根据这一个情形，我们奔豚病来这儿，我就是用这一个介绍一下。可见奔豚病啊，是一种发作性儿的神经证。他是发作性的，不发作没有，这么一种病。这么一种病它的原因很多呀。所以这个注《伤寒论》呐，硬说桂枝泻奔豚气，他也没明白这个奔豚。这一个原因很多，在《伤寒论》就有两个。他这一节儿说的什么呢？说病在表，应该发汗，但以烧针劫使大汗出啊，乃非法的治疗。这一个我注那《伤寒论》也这么注的，这是一种非法的治疗。他由于大汗出，病必不除。大汗表不解，本易导致气上冲啊，就容易使之气上冲，啊。这一个咱们讲桂枝甘草汤都讲了。如果针处被寒，这个被寒，这古人的看法儿

了，拿着现在说就是感染。红肿如核者，这更促进，啊，气上冲的加剧，啊。他又加上这个感染了。这个更能够促进这个气上冲的加剧了。故必发奔豚，啊。气从少腹，上冲心者，即其后也。这个奔豚病啊，就是气从少腹上冲心胸…啊，咽喉嘛。这就是他的一个证候。宜灸其核上各一壮，以治针出被寒，与桂枝加桂汤以解外，并治奔豚也。这一个奔豚呐，需要桂枝加桂治。那赵绍琴他遇着一人病呀，是这个，我说用桂枝加桂，他治好了。下回他又遇着一个，又用桂枝加桂，哎呀！他又问我，他说这怎么不好使了呢？我说那一个呀，他是在这个表证的基础上，他气上冲，由于气上冲而引的这一个，这一种神经证候，啊。他是，他这个…啊，要不是气上冲，要有气上冲挟水上冲，那就是苓桂枣甘汤。他脐下悸，你像那个什么，那个…那个…那个，那个《金匱要略》明明它是三段，还一个就是这个奔豚汤。奔豚汤它是李根白皮，啊，葛根、黄芩这一类的药。他是一种这个，在少阳这一种证候挟热，啊，这一种的奔豚。所以奔豚的造成是多种多样儿，就是辨证，总而言之辨方证啊，这也是很清楚啊。你不能见着奔豚，就吃桂枝加桂，那哪儿对，他不对。唉呀！所以他这一个就是。关于桂枝加桂汤证的探讨，书中论治虽仅上述一条啊，但也很清楚说明了桂枝加桂汤证或者桂枝汤证而气上冲剧甚者，剧甚者达到高度了，他就发作这个情形。那么你要说是奔豚，奔豚它也治嘛，啊。可是他是…他得在这个桂枝汤证基础上，他有表证，他表证没好，要没有表，要是没有表证这一种这个奔豚汤你用桂枝汤哪行啊，那不行啊。所以我这一回呀，把这个东西是，费点心思把它…我以前这个都有，啊，就是这个落末了儿，这一个…这一个方证啊，没解…没解释，就是没讨论。尤其这个“一节”的，需要讨论。你像那个桂枝加芍药。桂枝加芍药，他明明底下说，啊，他这个太阴病，那个…那一段呐，那也很精彩。那张仲景的意思啊，你像…你像这个太阳病也是，“脉浮，头项强痛而恶寒”，准得包括这一些的证候说明这个太阳病。你光一个

头痛能说太阳病吗？阳明病也头痛，啊，你要说光一个恶寒也不行，那三阴病也都恶寒呐。他准得脉浮，头项强痛而恶寒，这才是太阳病。这个太阴病也是啊，太阴病的提纲明明写的，啊，太阴之为病，他有腹满，他要是吐，他这里头停水，他那么个腹满。而且这一种水呀，他那个肠胃太虚了，他失去收摄，他要下利，自下利。所以他搁个自利益甚。自利益甚，时腹自痛。你看张仲景特别把这一段，啊，“本太阳病，医反下之，因而腹满时痛者，属太阴也”。他不是说“属太阴病”啊。他说这个太阴病也有腹满时痛，这一个腹满时痛啊，他说就证候来说，个别的这个证…证候，它是属太阴。但是它与太阴不一样啊，他这个腹满既不是虚满，他那个疼痛，也不是他那个寒痛。他那个纯粹寒刺激那个肠粘膜，你看那个大建中汤证，那个腹皮起伏，啊，那他刺激到那个分气上。那他怎么不疼啊，他疼的厉害的呢。这一个不是啊，这一个纯粹是由于他这个吃泻药，啊，他是误治了。哎，因而使这个腹肌呀，发痉挛。怎么痉挛？肌肉不和了。这一个他还没整个陷到里头去，就是肌肉不和了。他肌肉发痉挛，就是咱们说“急”。

“小腹急”那个“急”，急就是满。他这个拘挛的厉害，是肌肉拘挛都用芍药啊，芍药好使的很呐。他达到一个相当程度，他就是病人感觉自觉有满，憋的慌，啊。而且呢，有时候他也痛。这都是这个痉挛上造成的。这就是治腹肌不和了，他吃泻药，造成这么一个。张仲景特别提这一个干什么呢？他让你辨证要，不要片面看问题，片面看问题还弄错了，那就当太阴病治还行了？所以在底下怕你不明白。“大实痛者”，啊，这一个，没…没…没…没陷里呢？要陷到里了，他变成阳明病这个“大实痛”了，啊，那还得加大黄呢，你光这一个还不够了，是吧？当然也有这一个病存在，但是同时里头也实了。所以他要是，啊，桂枝加大黄 汤主之。加芍药还要加大黄。这个怎么能是个太阴病啊？这个统统是王叔和…告诉你，他这个张仲景这一段不定在哪儿呢？王叔和呀，他编次的时候啊，看着太阴病，他都往 那里

头归…你…咱们来看看这个伤寒论，这就笑话了。你看看太阴病，太阴病现在变成这么三个方子，一个，啊，桂枝汤方儿，一个就是桂枝加芍药，一个就是桂枝加大黄，旁的没了。这太阴病叫什么太阴病啊，这与这个提纲怎么来解释啊？所以他们这些呀，从古到今呐，研究这个书啊，他就不…在这上看不出问题来！我敢说，我没有那个，我不是抄人的东西。我看这东西他有问题，太阴病，桂枝汤，啊，桂枝加芍药，这都是一种这个解表解热的基础上啊，那么太阴病他不能发汗呐。反发其汗那不行的。那…那…那…那么虚寒的那个东西。所以他主要的，张仲景这个东西，不定在…在太阳篇里哪一块儿呢。他见着有属太阴，哎，也给弄这儿来了，他就弄得…把这个太阴病啊，弄的不是玩艺了。所以我写那个三阴篇，我费了挺大力气，啊。这个方证就是这样子，这个主要的精神，啊…你要是片面来用药那是十有八九要错呀，啊。就是一个方剂有他一个一定的适应证，得研究，啊。根据仲景的这个议论。咱们通过他的议论，我做一个小结。我现在要做这一步工作。以前我那个东西也都有，但是我这个，也是王八吃秤砣，心里有数，没写出来。我这回都把他提出来。你要有时间我还希望你好好搞，啊。这一个东西呀，这个人呐……（音频缺如）。

阴阳辨证论

胡希恕：……怎么说的，啊，这个阴阳啊，在这个，在这个中国这个哲学里头啊，它这是两个抽象名词。它是多所指。你比方说吧，他就是这个，毛主席讲那个“矛盾定律”，有前就有后。所以，在中医里头这个，前他也说是阳，后说是阴，他有个比方，出土的就是阳，没出土的叫阴，他拿那个三阳说，他说将一出土，还没出土，哎，这就是叫少阳，啊。他那个，所以这个阴阳啊，在这个中国这个，一般的这个哲学里头啊，用得非常广泛，不是只指那一个。他这个在这个《内经》里头呢，他是单独把这个气血分开了，就是气为阳，血为阴，所以有营血，这一个卫气之说，这还纯是这个东西。哎，那是专就人身上这个，啊，人身上这个组织，这个物质上来…来看的，也有时候内脏他叫做阴，外表就叫做阳，说“阳气入阴故也”，那不是跑到这个三阴病去了，不是的。哎，他有表…没有表证了，入里了，阳气入阴。所以那个《内经》上那个阴阳呀，那是普遍得很，他那儿都用，那不像咱们后世医书，那它就是死劲咬上了。热是阳，啊，这个寒就是阴。这…这…这…这，所以《内经》上明明说的，说“左右者，阴阳之道路也，水火者，阴阳之征象也”，啊，这个阴阳这个东西啊，“水火”，一个是性寒，一个是性热的，这两个东西，这是对立的東西。这就是阴阳的征象，啊。他后世就把这个水火呀，整个的这两个就是指着阴阳。后世这个这个…这个，这个医家眼界窄得很，那…那…那错的地方太多呀。你要是拿它代表呢，也行，不是不行。这个阴阳…这个八纲阴阳不是那个。

学生：那八…《伤寒论》不就是八纲吗？

胡老：啊？就是啊。

学生：八纲它是从证儿来说的。

胡老：这就是证，阳证、阴证嘛。

学生：阳证、阴证？

胡老：嗯。

学生：是症状的特点？

胡老：哎！

学生：他没讲那个生理，他没讲。

胡老：他古人不讲生理，他讲不出来。那讲就得瞎说，那后世那个瞎说，瞪着眼睛瞎说，讲还不如不讲呢。

学生：那个……

胡老：这个东西呀，据我看……（音频缺如）

药物辨证论

胡希恕：……你一定要研究药物啊，这药物也不…也不确实认识啊。你看拿那个芍药说吧。脚挛急，他用芍药，腹挛痛…腹挛急，他也是用芍药，啊。它也有缓痛作用。那么推而言之，凡是这个组织啊，失和，拘挛，抽，它都治。你忘了，那门诊那一个小便抽，我给他吃一两芍药，就是芍药甘草两味嘛，吃了就好了。

胡老：那一阵你来了没来？

学生：没见。

胡老：啊，那个同学他们都…那个什么…他们跟着实习他们都抄了。那个家伙高兴透了。他小便抽得厉害呀，他都抽没了，啊，他吃了就是…就好了。所以他是那个地方抽，芍药都治，就是拒挛、痉挛、拒急，它都治！那么那个桂枝加芍药就不是了？还是那一个呀！药…他就是那么一个，他这个肌肉啊，失和了啊，误治什么都容易使之他这样子。哎！他发痉挛。你要是在这个局部地方发痉挛，他各式各样的，他这个腹肌，他这个发痉挛他肚子他要疼。这个讲起这个我写完了，你可以好好研究研究。

学生：他这个方证，原先我不知道有几个意义。

胡老：啊。

学生：这一个是辨证。

胡老：啊。

学生：一个是治疗，这一个是研究药。

胡老：他这个……

学生：都有…都有重要意义嘞。

胡老：他这个…他是由…由大纲变细则。这个谁认识东西都这样啊。

学生：就是啊。

胡老：你像咱们这个…这个政府办事也是啊。他先有大纲领，纲领了有细目。到了细目就是具体的东西了。

学生：就是啊，方证是具体的。

胡老：哎！它是最具体了，最后了它是。

学生：可是，现在中医学院搞的，就是以法代方，搞这个。

胡老：哈，这才是瞎扯呢。

学生：不过现在，他是中医教材他这么搞了。

课间交谈

学生 1：我十几还出过水痘。

胡老：啊。

学生 1：也到每年都气管炎。得了回肺炎嘛，正好是考初中时候。

学生 2：水痘没关系啊。

学生 1：啊。跟那个也是合并症了。净咳嗽黄痰、脓痰。晕晕乎乎的。后来，到了一个月才好啊。

学生 2：水痘啊？

学生：啊。过了一个月，我上学才好啊。可是每年都犯气管炎。咳好多脓痰，弄好几个星期才好。后来到初三，练长跑嘛，慢慢练练才好了。（音频 042 完）

胡老讲柴胡剂

胡希恕：（音频 043 始）……当然是要是挂一漏十啊，这个东西他不能够太全面，只是个概要吧。这个柴胡剂呀，在仲景书里头啊，共计有八首，是吧？这大家都知道的。那么这个其中啊，你像柴胡去半夏加栝蒌根，啊，柴胡加龙骨牡蛎，柴胡桂枝汤，是吧？那么…这个…还有一个…啊，那么这几个方剂呀，都是一个小柴胡的一个加减方或者合方。所以我们今天不讲，啊，那么我们讲那个加减方、合方啊，对于这几个主要的方剂能够掌握，这一个自然就能够…啊，能够掌握的。那么今天要是开始讨论的呢，就是小柴胡汤，啊，大柴胡汤、柴胡桂姜汤、四逆散，这四个。那么这四个之中啊，都是以小柴胡汤是个基础。那么，所以我们必需把小柴胡汤搞明白。那么对其它的柴胡剂呀，才能够更容易理解。那么现在我们就…啊，先谈一谈这个小柴胡汤。那么小柴胡汤这个药物组成啊，啊，这一个大概诸位都清楚，我不必写了。我只是说一说就得了。那么小柴胡汤呢，是以柴胡为主药，这个柴胡的这个主治啊，我们首先要把它明确。那么这一个，这一个小柴胡汤啊，在这个《本经》上讲啊，它是苦平，啊。那么说它这个主治呢，是“心腹肠胃中结气”。心腹就是心腹间，啊。就是心下的心呐，啊，跟腹中…这中间，那么这是半表半里这个部位了，啊，就是胸腹两个腔间，腹腔、胸腔。“肠胃中”，他不但能够治这个胸腹腔间，在肠胃中，里头有“结气、积聚”。这个积聚指的肠胃里头的事儿了。那么这个…这个气呀，是个无形的，积聚是个有形的。无论是胸腹腔间之结气，或肠胃中的积聚，他都能治，是吧？“寒热邪气”，这一个指着外邪了。外邪入内，啊，发…发寒热，它也能去这一个。那么这一个主要的就是“厥冷”，去热，是吧？古人虽然说了“寒热邪气”啊，他是发烧怕冷了，就是在这个柴胡剂里往来寒热

了，他主要还是热。那么根据这一个说明这个柴胡主什么呢？它既无形的结气与这个有形的积聚全使人，啊，所以他治胸胁苦满，这个地方，他结气也好，有东西也好，在这个胸腹间呐，尤其这个，他这个…啊，柴胡剂偏于治两胁。在这一个地方的满，苦满，“苦满者”就满之甚也，以满为苦，是吧？他治这一个。同时他还能够去热，他是一种解热药，啊，那么他是有一个舒气行滞。舒气行滞的这么一种解热药。那么他表现呢，就是胸胁苦满了，是吧？这是，在仲景这个书里头他有胸胁苦满，我们根据这个也知道他必有胸胁苦满。那么他这个作用起什么做用呢？“推陈致新”。他能够去…啊，陈旧的这个腐秽东西，而能致新、生新。所以这是柴胡的这个药的，这根据《神农本草经》上来看它起的作用。这个我们得知道。有一些对于柴胡啊，又是升提了，又是发散了，这是错误的。所以我们必需，首先，研究柴胡剂嘛，这个柴胡剂这个主治必需搞清楚。那么这一个方子以它为主，那么同时呢，它佐以黄芩。这个黄芩是苦寒药了，是除热解烦呐。那么这个他佐以黄芩呐，就是为除热解烦的。同时这个药里还有半夏、生姜，啊，就是小半夏汤了。这个咱们都知道治呕，是吧？那个半夏下气、治呕，啊，它也去水气。用生姜治呕，这个都知道了。他搁半夏生姜呢，就是治呕，他胃有停饮、停水而发生呕逆。所以他这里头搁个半夏、生姜。那么另外呢？他有些健胃的药，就是人参、甘草、大枣，这个它很重要，啊。那么这个柴胡剂呀，这一个，为什么他搁补药啊？那么就这个邪由表进入半表半里，他都由于这个胃气虚。这一个，一会儿我们详细…详细讲啊。那么健胃呢，就能够生津液。这个胃就是这个，啊，水谷之海，营卫之源嘛。那么他健胃就要生气血，啊，生津液。那么，徐灵胎讲过，他说这小柴胡汤之妙在人参，就是这个道理。底下我们讲两段呐。必须知道的在《伤寒论》里头。头一段我不讲了，啊。这个“伤寒中风五六日啊，胸胁苦满”这一段我不讲了。这一个，啊，大概诸位都可以看《伤寒论》上都知道。有那么

一节儿“血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏，结于胁下”，这个必须要知道。那么，这才知道这个人参的重要。他这个，这一个病从表进到半表半里，为什么？所以这一个在中医里头啊，常讲这一个“正邪纷争”。这在这个中医临床上这是个重要问题呀。这个人的这个，这个机体呀，它是老对付病邪的，它一时也不停。所以在表证的时候，啊，这一个“邪气交争于骨肉”，这是《内经》上的，啊。你们看一看这个《内经》啊，刺热病论，其间有个“阴阳交”这么一段，有这个，有这一段“夫邪气交争于骨肉”。这个病在表的时候，邪气，气是什么？就是，有这个《内经》上讲就是精气。也就是合气血而言之，更清楚就是津液。它在表的时候啊，这个人体呀，往这个体表输送大量的津液，就是气血。血管里头液体也多，血管外头里头，啊，液体也多。总而言之就是津液了。精气者就是养人之精真之气呀。那么拿着现在的话说呢，就说个饮食入胃吸收这个营养成份，是吧？就是水谷化和物了，拿着这个西医的观点看。那么这个古人叫精气。这个精气和邪在体表打仗，体表就是这个躯壳儿，就是骨、肉，啊，筋、皮肤所组成这个躯壳了。在这个地方交争于骨肉。为什么？想发汗。他那…那一段说的很好了，所以呀“汗出者精胜也”，啊，那个精气就胜了，啊，那就是身上一出汗就好了。那么也有精不胜的，他阴阳交就是精不胜，啊。我们今天不多讲这些闲话，你们回去看看这一段就行。

那么这一个少阳病怎么发汗，他这个精气不足以御表了，在表上他打不胜仗了。这个人体呀，还想对付邪气，他要转移防线了，他把这个体表这个精气呀，往里头撤。就是汇于内呀。那么这个时候血弱气尽，这个“血弱气尽”这么来的。它这个邪气呀，他这个由表往里头来，人的精气从表想往外去，想要发汗，那么在这一段的这个交争啊，这个正不足以胜邪了，怎么办呢？他也不坐以待毙。他要转移防线，啊。他就是，所以这个在体表上啊，这个正气不足了，就是精气

不足了，所以这个，这段书啊“血弱气尽”，不是身上虚，血也没有了，气也没有了，那人要死了。“腠理开”，他第二句话，在体表上血弱气尽，所以这个腠理要疏松，啊，那么这个“邪气因入”。这个这个本书就是我说的这个，啊，与正气相搏，啊，结于胁下。就是结气了，咱们头前儿就说这个，这个“结气”结于胁下。这一段很重要，要不然你不知道柴胡汤怎么个事儿，啊。那么这一个，他这邪气往里头入呀，这个正气可是他不退却呀，他就在这个胸腹腔间胁下这个部位，与这个邪气在这一块儿开始斗争。那么这一个时候啊，邪往里头，正把它往外头推，咱们讲这个太阳病都恶寒，我们讲阳明病都恶热。这一个时候，这一个…这个邪气呀，有的时候正啊，往外推得相当有力量，接近于表，他就恶寒；有的时候这个邪的这个纷争得厉害，啊，这个正气有些不支，近于里，则恶热。所以“往来寒热”。那么这一个正邪在纷争，往来寒热就作，也有的时候它停止，就休息，所以“休作有时”。这个“往来寒热”这么来的，啊。根据这个书，这个张仲景这个，啊，这一段的论述。完了他又说“邪高痛下，故使呕也”。邪高，指着这个胁这个地方说的。胁下这个部位，邪在这一个地方。比哪儿高呢？比这个胃肠高。胃肠在胁以下嘛。这个半表半里呀，他提出个脏腑相连嘛。邪高痛下，啊，这一个地方，上边心肺，它就是胸腹腔间呐，指着这个半表半里这个部位啊，上边有心，左边心，右边肺，是吧？那么旁边呢，右边肝，左边脾。下边紧接胃肠，啊。所以他说“脏腑相连”呐，啊，那么这个半表半里这个部位呀，为诸脏腑所在之地呀，他是脏腑相连的。那么邪在胁下，而胃肠又在胁下呀，啊，这个在上，这个在下。邪在上，那么胃肠与它相连。这块儿有邪，影响胃肠。所以小柴胡汤也治肚子疼。说“邪高痛下”，指着这一个，啊，胃肠疼呀，故使呕也。上下夹攻，他哪有不呕的嘛，这一个用小柴胡汤主之。这一段很得要。这一段说明什么了？我们就说明加人参的问题了。血弱气尽，这就是胃气呀，啊，它不振作，那么这一个时

候你要，我们来健胃，啊，益气。这是这这个时候治疗的一个，主要的一个，啊，一个设…啊，一个妙举吧。他一者防这个疾病继续往里侵；第二个助正却邪呀。助正，血弱气尽嘛，啊，那么这个时候必须要健胃。胃气一振，啊，血气充，啊。血气充，这个邪气在加上这个药物的治疗，自然就好了。所以小柴胡汤之妙，妙在人参，就根据这一个。那我们这个方剂的解释就到这儿了，啊。那么对于这个《伤寒论》和《金匱要略》里头啊，有多少节儿，我没法今天不能细讲了，啊。这一个，啊…同志们回去自己看一看就行了。那么我们现在呢，根据，啊，仲景书中我们可以做个总结。底下我这有，大概是这么几条。那么这个柴胡有四个主证呀，啊，就是胸胁苦满，往来寒热，啊，默默不欲饮食，心烦喜呕。这是用小柴胡汤的四个主证。那么他有些这或然证状，是吧？这一个就我们方才讲了。因为这个半表半里这个部位呀，脏腑相连。这个邪充斥在这一个部位，能够波及到许多脏腑发病。那不是准发一个，这个，啊，器质病变了，影响他这个功能。所以我们这个“或”很多，啊，或心下悸、小便不利、啊，或咳、或渴、或胁下痞硬。他影响到肝脾，胁下痞硬，影响到胃，胃不和他就要渴，影响到肺他就要咳，可是这些的这个或然的客证，这个不是个主要的，只要有四证存在都可以治疗。所以这个书啊，你们看这个《伤寒论》上有些这个，啊，加减方不对，那个要不得。他为什么有这些或然的证状，无论有无都用小柴胡汤呢？小柴胡汤啊，它是驱这个部位之邪，邪去了，自然就没问题了，都可以好了，所以这也是中医的妙处，啊。不要加味，你们看后头的这个，啊。那么有些这个事实可以告诉我们，不必加味。那么我们总结仲景这个书呀，他第一条就是这四个主要证状。那么他还说，啊，这个，这个病啊，见柴胡证，见一即是，不必悉俱，也就指这四个主证说的，但是也不是随便有一个证状你就要用小柴胡汤。也得详细观察其它的问题的。他这里头有例子。那么根据这个书的这个总结，就有这么，大概九…啊，可以说是

九项吧：第一个，就是四个主证，啊，要是具备的话，那没问题的。第二个，就是“太阳病，脉浮细，嗜卧而胸满胁痛者”。这我都略略说一说，啊。这都这个书上有的。这一段不过也挺重要，在我们临床上啊，你们自管看，这很多了，有的这个感冒，或者流感，他没过几天，这个人呐，身上没力气了，这阵儿你摸他脉，虽然浮，但是细。为什么细呀？就是血弱气尽，在表的津液虚了，气血不足，不足于表，所以虽浮它细。这个人怎么样？而嗜卧，困倦的很，这一个在临床太多了。有的是这个感冒，啊，经过发汗，吃点其它的表药。又或者西医给经过这个，啊，注射，表是没有了，可是病人呐，就是烧不退，或者说就觉得没力气。这个临床多的很呐，这个都是小柴胡汤证。那么再有热你加上石膏，是非常好使。可惜大家这个，这个柴胡啊，这后世把它列为升提呀，又是散呐，在我年轻的时候，用柴胡的人很少，不敢用。尤其吴鞠通说的，啊，这种热病啊，吃点柴胡就简直就是受不了，就了不得，不能治了，更吓人，是吧？就没人敢用，实质不是这样。那么这一条就说明这一点。他说是太阳病，啊，脉浮细，而嗜卧，胸满胁痛，就可以用。“身热恶风，颈项强，胁下痛，手足温而渴者”。这个颈项，咱们这个脖子啊，两侧谓之颈，后头谓之项。这个两侧呀，属少阳，后头属太阳，也是太阳病没罢。他不光项强，他是颈也强，啊，颈是两侧。“胁下满”，胁下满这是个用柴胡证的一个主要证候。“手足温而渴者”，啊，那么这一个手足温而渴呀，这个病就是，啊，有侵于里之势了。看这个看着又有表，又有里，为什么用小柴胡汤呢？这个注意。凡是有柴胡证，既不能汗，又不能下。这个少阳病也如此的。少阳病禁汗、禁下。因为他在半表半里嘛，这个地方。所以有表证，有里证，只是见柴胡证，用柴胡剂没错的。这一个…这一段也挺重要。那么再有呢？他提个妇人热入血室，啊。她往来寒热呀，啊，经来适断呐，啊，胸胁满，也可以用小柴胡汤，那么它起推陈致新的作用嘛。发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去

者，也可以用小柴胡汤。这个发潮热这是阳明里实的一个问题了，也就由于胸胁满不去。柴胡证存在，啊，你用柴胡汤就行。这个“大便溏”他是泻肚的，啊。他由于热，那么这个，咱们在这个热利，这一类的病啊，要说痢疾，有热，有用柴胡汤的机会，他要是呕，那么再有胸胁满，那你用小柴胡汤没错的，啊。“胁下硬满，不大便而呕，舌上白苔”。不大便这也是个阳明内实的一个…一个反应了，啊。但是“而呕”，啊，“胁下又硬满”，这柴胡证。所以这个小柴胡汤啊，既能够治大便…啊，泄、溏，也能治大便不通。所以他这个方剂应用基本很多。这一个治大便不通呢，那个书上有“上焦得通，津液得下，胃气因和”，啊。你们回去看看《伤寒论》就好了，这一个我都不细讲，没法细讲，太多。“呕而发热者”，啊，也可以用，啊。所以见一即是啊，呕这是柴胡证的一个…一个证。他要没有发热的这个呕不行，那是小半夏汤证。要发热呢？那就是小柴胡汤证。所以那根据《伤寒论》说，啊，“但见一证便是，不必悉俱”，也不是随便说的，他底下有例子。要是“呕而发热”肯定用小柴胡汤。“诸黄腹痛而呕者”，黄疸病啊，啊，现在咱们这个，啊，急性黄疸性肝炎也在内。要是呕，啊，再有腹痛，所以小柴胡治腹痛，啊，咱们在头一节儿那邪高痛下…那么也可以用它。

“新产妇人”这是《金匱》上的，昏迷而悸。昏迷就是，在《金匱要略》里他说的是这个“郁冒”啊，“妇人郁冒”，这两个字，啊。这个郁冒啊，就是昏迷，同时抽，大便干。那么这一个呢，小柴胡汤可以治疗。这一个我们看出来这个，这个柴胡啊，与脑系有…啊，起作用。他默默不欲饮食，就是昏昏然呐。那么他这一个在这个《金匱要略》里头呀，啊，呕不能食，这是柴胡证，那么这个妇人这三种病同时发作：昏迷、抽，啊，大便干。那么要是呕而不能食，你用小柴胡汤就行。所以中医讲辨证啊，他没有柴胡证，你用柴胡汤那是有害无疑。有了柴胡证，无论什么病，用它都有效。所以，啊，那我的主

张这个…这个方药的知识非有不可，不然的话，你不会用药的。

到这儿呀，我们把这个小柴胡汤根据仲景书中的这个，啊，归纳他的书做个结论，这个，啊，同志们回去呀，你们看看《伤寒》……

（音频缺如）……中医界犯这个的很多了，这个就是西医的一种疗法。这不是中医的辨证论治，啊。脑袋疼了搁个什么药，搁点白芷吧，治脑袋痛，啊，发烧吧，搁点什么药，祛热，肚子疼了搁什么药，这叫做记药以治病，这个不行；这个在徐灵胎讲的好，这个叫做有药无方！一大堆药搁到一起，什么也不是，啊，看着这个药是治头痛，其实它是坏药，不治头痛的，它药与药之间有作用。那么守方以治病行不行？也不行。你像我们讲的柴胡证，啊，在仲景说的够详细了，就根据他这一个守住柴胡汤治病，行不行？也不行。那一个叫做有方无药。因为什么？这个疾病万变呐，他没有恰好小柴胡汤证的，很少，啊。稍有出入，这个方子就…你就得想法变化，这是咱们说加减呐。再不就是合方。可加减，则加减，需要合方你把这方子合用就行了。否则不足以言医呀。这是我的看法儿。你也不能尽柴胡汤之用，就说是…但凡是，你要是遇着我们上边所说的这个用小柴胡汤是可以的。可惜，这个病恰好这么来的少，那你怎么办呢？就不能尽柴胡汤之用，所以这个徐灵胎他…他讲的，在这个《徐氏十六种》上就有。他说，记药以治病，这个有药无方；或者是持方以治病，守着方，守株待兔那么个干法，你也不会治病，这个叫做有方无药。所以一个当大夫的，既要知方，又要知药。方剂心中得有数，就像我们对于小柴胡汤这个了解。同时呢，你得知道药，药究其实那个药起什么作用，那个药与那个药配伍发挥什么作用。你心里得有这个数，没有这个数不行。这样子你才能应变无穷，啊。你像这个小柴胡汤证吧，他既是个柴胡证，我们心里说，哎呀，他得用柴胡。可是他这个变化，不恰好小柴胡汤，你得想法，该加减，你加减，啊，该合方你合方。这才能够应变无穷啊，而广柴胡之用。对于小柴胡汤应用呀，你才能够，啊，能够有所

发挥了。才能尽其用，不然的话不行。那么现在，啊，这个加减合方这个东西也太多，啊，太广泛了。今天我讲的，就是我经常用的，啊，没用的，我一个也不讲，而且绝对有验的，我们略略的讲这么，啊，一些。

第一个“小柴胡汤加石膏”，这个最常用了，啊。那么这个石膏加多少呢？这石膏一般呐，也就是 40 克——100 克吧，啊，40 到 100。起码要用啊，就是五六十克，45 克。啊，40 克以上。因为石膏这个药大家要知道，有些人怕。他是个石头，质重，而溶解相当困难。它溶解水的成分相当的少啊，假设你加的分量不够，旁的药起作用了，石膏没起作用，啊。这个我见着很多了，就是麻杏石甘汤这个药，也配合石膏了，可石膏用的非常的少，麻黄作用，啊，发作，出大汗。本来这个麻黄配伍石膏它止汗的，你们看那个麻杏石甘汤，汗出而喘，他用麻杏石甘。汗出啊，他治汗出。你石膏用少了，他非大出汗不可，那倒糟糕了，是吧？所以这个石膏你必须要有分量用…用对头。它质重，啊，非常沉。所以我们用小柴胡加石膏，这个石膏量呀，我一般用起码用 45 克，也可以少用，小孩子，啊，也可以少用。尤其这个小柴胡汤，我们方才讲了，有健胃药，这个石膏害胃呀，啊。可是它有些健胃药在里头呢，它没有什么大问题的。那么这一个方子净治什么呢？这个在临床的这个反应啊，我们先从感冒讲起，啊。感冒啊，流感呐，以至于一般的急性传染病，在开始都得的是表证了，就是太阳病。可是这一个阶段，经过治疗，或者他没治，很快，两三天，啊，不必到四五天，他这个表证就没了，没了这个人所现的就我们方才讲这个脉浮细而嗜卧，啊，或者是恶心呕吐啊，胸胁满呐，这就是小柴胡汤证。那么小柴胡汤再进一步，他内热就要有了，就是里热了，啊，口干、舌燥，甚至于渴，那么这个时候用小柴胡汤就不行了，得加石膏。这个病人的反应的呀，很多样儿，“头痛如裂”，这个在临床上很多了，“高烧不退”，啊，经过，打过针，输过液，啊，也兴吃

过发汗药，没有表证了，但是高烧不退。那么这个时候我们看到柴胡证，确然。另外他有石膏证，石膏证什么呢？就是“口干、舌燥、舌白苔”。白苔发燥，啊，不是滑，这时候你加上石膏没错的。他有些特殊的反应，脑袋特别疼，或者是晕，这个热也能使之头痛，啊，也能使着头晕。也有不头疼，不头晕的，他感觉什么呢？口鼻如冒火呀，他自己就说，唉呀，我这简直，这个出气呀，热的很。那你小柴胡汤也得加石膏。小柴胡汤的解热呀，没有这么大的力量。他总而言之，他口舌干燥，起码口舌干燥。可是得有柴胡证呀。你光听我讲石膏这一点儿不行，他得有柴胡证。柴胡证什么呢？就我们上边所讲那个，胸胁满呀，呕而发热呀，等等的吧，啊，这个你用小柴胡加石膏，是百试百验。这一个，啊，这是我在临床上老用。可是有些同志们不敢…不这么用，不这么用你们来试试就不行。这个多的很。那么这是说在这个，啊，有表证传入半表半里，他首先要发生柴胡证。

进一步，他要是，啊，他病还往里了，里边有热了，就是发现石膏证。那么净什么病有这个呢？这个小柴胡加石膏还有一些特殊的作用啊，你像我们遇着这个腮腺炎，啊，或者是，是腺状体发炎它都治啊！耳上下肿，啊，那么这个淋巴腺肿，妇人的这个乳腺癌…乳腺癌我说错了，乳腺炎。就是这个，啊，这个奶肿啊，它都治。只要是没到化脓的这个程度，用它是马上就立验。那么再有呢，小儿肺炎最多了。这一个我用它治很多很多了。这个小儿肺炎呐，现小柴胡汤证，所以小柴胡汤加石膏最合适不过！非常好使。那么就是用麻杏石甘汤之后了，我方才说麻杏石甘汤嘛。这个是发汗的药物啊，这个麻黄这一类的药物用过之后不能再用。这这个时候，大概他都是胸胁满，呕逆不食，啊，发生小柴胡加…啊，加石膏证。这个我治多了。这个小儿啊，甚至于这个，没满月的小孩子，我都治过。用奶瓶啊，他把这个…给小孩子频服，你别一下就给吃多了。那非常的…也非常的快，这很多，很多呀，啊。后头我也有例子。有例子，啊，不像我说这么…

这么清楚，这个也多的很。我记得咱们有个同学呢，叫刘玉竹，现在这个人来中医院呢。他的小孩子得肺炎。因为他是咱们这儿毕业的学生，他找我给看，我就给他吃这药，很快就好，快得很，他以前吃麻杏石甘汤，越吃越不行，啊。这是说是我们根据这个常见的疾病而见这个小柴胡加石膏证。略略举几个例子，啊。

第二，小柴胡加芍药。这个芍药咱们都知道，它治腹急痛。这个小建中汤不是有个加芍药嘛，芍药加量。也就是小柴胡汤里头这个芍药加 12 克，啊，到 18 克。这个芍药不止于治肚子疼。所以在这个泻肚的时候有时候也用它，啊。那么小柴胡加芍药呢，当然是小柴胡汤证，同时他肚子疼的，啊，特别厉害。急痛，他有点拘急痛，啊，那更好了，我们可以加芍药。那么在这个痢疾呀，啊，所以咱们说拧肠刮肚的这么疼，用小柴胡加芍药就可以治。头前儿咱们讲小柴胡汤，不也治大便稀嘛。胸胁满不去，啊，大便稀、大便溏、小便自可，不小柴胡汤主之嘛。这也是《伤寒论》里头有的。那么我们遇着这种下利，就是痢疾，啊，有柴胡证，没柴胡证你可不能用，啊。有柴胡证，而腹痛得厉害的话，可以用小柴胡加芍药。这个小孩子痢疾也多，这也很奇怪。这个小孩子病啊，现这个小柴胡汤证多得很。这个让我说这个道理我也没法说，啊。这根据这个客观事实了。小孩子现这个证状最多，大人也有。尤其呕吐，有呕。我们治痢疾，这个开始啊，都要用…啊，多攻少补啊！可是呕你可加小心，啊！所以伤寒呕多，不可下，啊。这个时候大概柴胡证那是没问题的，你用大柴胡汤也没问题呀，啊。他不像那个承气汤。但是这个，假设遇着痢疾，我们加芍药，他口舌干呢，又有石膏证，你再加石膏，也没问题。如果里急后重，蹲肚啊，蹲得厉害，你还得加大黄。所以这个加减的这个，啊，啊…这种，我们用其它的治痢疾也是一样的。要是里急后重，你非用大黄不可。

第三，小柴胡加桔梗汤，这个方子也常用。这个桔梗啊，就是加

9 克，啊。这个不要加多，这个桔梗加多了能使人呕吐。这个方子，我们一般…这个桔梗汤，桔梗、甘草叫桔梗汤啊，他不治嗓子痛嘛。这一个就是我一般所见的这个，啊，啊…扁桃体发炎呐。这个病很多很多的。可是也得现柴胡证，我们不要认为呀，扁桃体一发炎有用小柴胡加桔梗的机会，可不能遇着嗓子疼，没有柴胡证，你也用小柴胡加桔梗那就坏了。都是这样的，话不反复说了。有柴胡证，嗓子疼，啊，那么就是一般常见的就是扁桃体发炎最多，可以加桔梗，如果口舌干燥，光桔梗也不行，还得加石膏，啊。这都上边一致下来的。

第四，这都常用的方子，小柴胡加吴茱萸汤。这个小柴胡汤啊，可以加吴茱萸。吴茱萸就是 9 克到 12 克。这个吴茱萸大家都知道，是吧？它治呕啊，食谷即呕者，吴茱萸汤主之嘛。这个头痛，头晕，呕呃甚者，就是呕吐，啊，厉害，这是吴茱萸汤证啊。我们这个平时见着这个所谓这个美尼尔氏证啊，啊，就是头晕，要是呕吐厉害的，就是用吴茱萸汤就行，吴茱汤就是吴茱萸、人参、生姜、大枣嘛。那么但是有柴胡证，你光用吴茱汤不行，你非配合柴胡汤不可。那么就是小柴胡汤证，啊，你加上吴茱萸，就等于小柴胡汤与吴茱萸汤的合方。这个病也挺多呀。不管他美尼尔证不美尼尔证，我们在临床上遇到人呐，呕吐厉害，比这个小柴胡汤的呕吐厉害，啊，甚至于不敢起来，头晕的厉害，头疼的厉害，你可以用小柴胡加吴茱萸。同时他口舌干燥呢，你加石膏也没问题的，不是说吴茱萸要是温性药，石膏是个寒性药，那没关系。这个方子也常用，也常见这一类的。

第五，小柴胡加橘皮汤。这个在小柴胡汤方里头，加橘皮，这个橘皮呀，20 克到 30 克。这个橘皮这个药，说法不一了，啊。那么最常用药，这个没什么大了去了，你多用没关系，那不是破气。这古人用它治哕逆呀，这个橘皮汤，就是橘皮配合生姜了，这个也是《金匱》上的。它有这个下气，祛…啊，镇咳，进食这些作用。能够治咳嗽，咳，能够进食，亢进食欲，所以治胃病的时候也常用。大量用没关系

的，啊。那么这一个方子，就是小柴胡汤证，有这些情形，哆逆，啊，或者是咳，或者不爱吃东西。都可以加橘皮。那么最常用的就是小孩子“干嗽”，没有痰，干咳嗽。所以这个百日嗽，有用它的机会，啊。这一个我也试验过。把这个大枣啊，增量。我们小柴胡汤大枣是四个，是吧？你可以增量七八个，治这个干嗽，就是百日嗽这一类的小孩子，挺惊人呐！他也咳嗽吐啊，哆逆嘛，所以把橘皮大量加，挺好使。

上面这几个呀，都是常用的加味。那其它还多了，没法普遍说。底下大概给介绍几个合方。

小柴胡汤与葛根汤合方。这个合方啊，我把这个合方办法，我给说一说。那么葛根汤这个方子呢，怎么个合方的法子啊？这么合方。这两个方子，相同的药，取大量；不相同药，你把它列出来就行了。你看看这个，这两个方子，小柴胡汤与这个葛根汤相同的药，有这个生姜，这一个相同，啊，有大枣，有炙草，其它没有了。所以在葛根汤里头啊，这几个，分量也都一样，就不要往里头加这个了，啊，这几个不要往里头加了。你就…啊，葛根，桂枝，麻黄，白芍就行了。他如果这个生姜 6 克，那么你就用这个 9 克就行了，不能搁 6 克。相同的，取其这个量大的用；不相同的，加进去，这就是合方的一个办法，啊。那么这个葛根汤与小柴胡汤的合方就根据上述这种办法，把这药物呀，并成一个方子。那么当然他第一个方子，这一个，对于这个病上来说呀，既有柴胡汤证，又有葛根汤证，那么这样子呢，你就把这个证相合，方也相合用就行的，这个很多，很多的。那么这就说是表证清楚，啊，而又有柴胡证。你比方这人发喘，这个小柴胡汤你怎么样子的加味它也不治喘啊，是不是？他与麻黄证没关系，那么这个，其它的恶寒也挺厉害，你就把葛根汤，合用小柴胡汤就行了，其它的都柴胡证。我们方才讲了，说这个少阳病啊，不能发汗，但是一起用行。就像我们讲那个太阳病，是吧？说太阳病不可下，但是你表…有表证，有里证，啊，先解表固然是没问题的，表里合用行不行？行

啊。你桂枝汤加芍药、大黄就是了。你可是不能够…他有表证，你不能不用解表药，而就下，那不行。这个少阳病也这样，有柴胡证，你不能发汗、可是用柴胡汤，配伍发汗药行不行呢？行！一样儿，跟我们讲那个。那么这一个就是的，这一个方剂应用的方面也挺多。就我们初得病的时候，他就是所谓合病啊，又有表，又有半表半里，就一同来的。这个重感冒，或者是，啊，流感什么，常有这种情形。你就把两个方子合起来用来，比单独发汗好得多。那么尤其是，啊，我们平时临床上这个哮喘呐，他如果是经过感冒诱发起来的，他以前固然是也有这个喘根了，啊，他寻常挺好，可是得了感冒了，这个喘起来了，同是也现柴胡证，你就用葛根合用小柴胡汤，非常好使这一个，这一个我也…后头也有病例，啊，挺多。如果口舌干燥呢？也得加石膏。所以这个加减呢，这个药物你脑子里得有，他口舌干燥，他不但有表，有半表半里，同时也有里了。这是一个。啊，小柴胡汤与葛根汤合方。

小柴胡汤与小陷胸汤合方，那么，这个，就是小柴胡汤加上栝蒌、黄连就行了，是吧？它这半夏有了，方才咱们讲这合方不就是嘛。半夏有了，半夏就不必…不必搁了。这个栝蒌这个药啊，它是宽胸、解痞、去痰，啊，也治咳嗽。那么小柴胡汤有这些情形，你可以与小陷胸汤合方。既有小柴胡汤证，又有小陷胸汤证，胸满闷呐，啊，那么心下这个地方堵得慌，啊，痰也多，可以加小陷胸汤。这一个方剂呀，一般应用的并不太多，但是肺结核应用的可能不少，啊。胸…心下闷塞，啊，痰嗽，有用的机会。但是肺结核单用这个合方，也有。有的时候他要是，咱们说骨蒸癆热呀，你还要配合这个“黄连解毒”，这一类的药。黄连解毒，这个“黄连解毒丸”按理说这个，啊，咱们医院上次我开就有。啊，以前这个药，是药铺都卖。要有带血呢，有的时候可以，啊，兼用泻心汤。这个肺结核这个病，这是一个虚热证。那么用柴胡证那是挺好的，咱们讲柴胡证这不有这个嘛，啊，又有补

药嘛。它是个健胃、去热，所以我们用这个大温补药不行的，他是一个虚、热。虚是应该吃点补药，但是热呢？得…得用寒性药。你不能
用温性药。所以这个肺结核没有吃黄芪的，啊，那么有看……（音频
043 完）（音频 044 始）……热它用苦寒药啊。那么用石膏就不行，
啊，这个肺结核有用石膏的机会，不是没有，啊。你看咱们用那个，
你像那个竹叶石膏汤，也常用，啊。咱们讲的柴胡剂了，就不讲那些
东西了，啊。那么对小柴胡汤啊，啊，这一个加减合方，今天就讲到
这儿， 啊。

……与小柴胡汤比较，它没有人参，可是它加上芍药、枳实、大
黄，去甘草，去人参、甘草。那么大柴胡汤为什么它这么组成呢？对
于这个药物和这个病…啊，这么用的道理，咱们暂时先知道。这个大
柴胡汤啊，我们方才讲小柴胡加石膏了，那么这个病，柴胡证，它波
及到里，就是波及到胃呀，起码是到胃呀。只热而不实，那么就是小
柴胡加石膏，光有热，不实，实在的“实”啊，我们都讲了。那么如
果“实”，这就是大柴胡汤证。“实”就是病已经侵到里而实。实，
偏于实，这个大柴胡汤就偏于实了。我们讲小柴胡汤啊，它里没病，
所以他搁人参，啊，起码是不实啊。他怕这个病啊往里头侵。那么里
既实了，你不要补了。补就关门抓贼了，是吧？所以这个人参、甘草
补益之品，反到碍事。以祛邪为主了，所以他加上芍药、枳实、大黄，
啊。逐实消胀挺快。所以这两个方剂不同吧。那么由于不同，这个证
候的主治也不一样。这个大柴胡汤啊，它也是柴胡证，也有胸胁满，
是吧？也有呕不欲食，心烦更不用说了，这都有的。那么多了什么呢？
心下就是胃的这个部位，急。这个“急”字啊，就咱们说这个寻常讲
就是一个“憋”，觉这块儿发“憋”，痞塞，啊。就是这个意思。不
痛快，而且觉堵的慌。这个“急”字是这个 意思。甚至于，他这个
心下这个部位结得轻，“急”；结的更厉害，又硬又满胀。那么那个
柴胡证，有了这个情形，说明里头啊，啊，半陷于里而为里实的证候。

那你非祛邪不可了，所以他搁芍药、枳实、大黄。那么邪在里不能补，得攻。所以人参、甘草，啊，补益之品去掉。那么其它是大同小异了，啊。就是这个病半陷于里而成里实之候者，其表现，他有枳实吧，枳实就治这个心下满嘛。心下急，甚至于硬满者，我们要用大柴胡汤。那么这一个，在书的这个，啊，原来的这一个，你们可以看一看，我不介绍，啊。那么底下呢，就是关于大柴胡汤的，就是临床…临床上一种体会了，啊，那么加味或者合方。那跟小柴胡汤是一样的。当然要有大柴胡证恰好，用大柴胡汤没问题的。可是有大柴胡汤证，又牵涉到其它的问题，啊，你光用大柴胡汤是不行的。

第一个，大柴胡加石膏汤，这个与小柴胡加石膏汤啊，这是挺衔接的一个药。他不但里实，而且里也有热。那么这个石膏这个量呢，跟我们小柴胡加石膏的量一样。这个原则问题，啊。我们方才讲小柴胡汤那一套，如果大便难，舌黄苔，他这个里一热，这个舌苔就发黄，啊。那你只用小柴胡汤就不行了。我们方才讲这个，尤其这个发高烧这个病啊，才多呢，啊。也就是表证解除了，发高烧，但是他全是小柴胡加石膏的样子，可是呢，舌苔黄，大便干，这个小柴胡汤就不行了，你非用大柴胡加石膏不可。这个临床上也很多了，这个我治很多很多的，啊。那么后头有这个病例。我现在给你们说一个就是，我治这么一个人，发了五十天的，五十多天高烧。这是一个于外国回来的。那么这个人呐，他就是当初得流感，发高烧，老是40上下度，五十多天，后来那个医院没办法了，就是请各医院这些专家呀，会诊。那么大家一看呐，他什么都用了，抗生素用遍了…输液，那么据西医的观点认为这个都…都试验了，而高烧不退，恐怕是癌变，把这个人差点给吓死，啊。这个病人呢，就是以前咱们北京站那个当过站长，叫政协主席。后来就找癌吧。是怎么找也找不着癌细胞，啊。这一块儿有个小包也给他做切片，啊。后来实在没办法了。他的主治大夫和我熟，他后来就找我。找我他一说呀，我就跟他说了，恐怕是流感。啊，

这个…这有的是啊，啊。他非让我去，我就去看去了。这个人呐，就我方才所说这个，舌黄苔、呕逆、不愿意吃东西、心下硬满，那都拒摠。就这么一个情形。我说就用大柴胡汤加石膏就行，吃了就好。就吃一付药，啊，后来当然他吃三付了，后来我回来了，他不烧了，他也还给他吃。后来他到一个礼拜就出院了。到现在这个人我常见，啊，他也没有癌。这个，这个多的很呀，我随便举一个严重的病例。我们在临床上遇着高烧，是由外感而来的，大便不干，像我们方才说小柴胡汤，小柴胡加石膏，百试百验。如果有里实之候，也有柴胡证，你用大柴胡加石膏，也是百试百验。这个我用多了。这个很多呀，你不给他用，它就不下去。

大柴胡加芒硝汤，那么这个就是大柴胡汤与这个调胃承气汤的合方，是吧？就是发潮热，啊，大便秘结，那么其它都柴胡证，那你就加芒硝吧。这个潮热，大但硬，他应该用承气汤，那么这一个，啊，就是我们说这个疫痢呀，有用它的机会，啊。我自己的孩子得这个毒性痢疾，我就用这个方子加减。就是大柴胡，啊，再加芒硝。我用的加石膏，因为他高烧的厉害，口舌干燥，啊。这也挺好使。那么发潮热，再说胡话，啊，用…用这个方子就对了。这个不过他没这个大柴胡加石膏应用的机会多。

大柴胡加橘皮汤。这一个咱们说，伤食这一类的，吃着了。这个橘皮这个药，奇怪，啊。你要一般用这一种泻下药呢？有的时候，啊，他要是…这个胃里头有所这个结…啊，吃东西存…啊，古人…你看那个《金匱要略》里有啊，他说由于吃这种鱼肉啊，他那个大便秘结呀，他用这个大黄橘皮汤，是吧？所以这个橘皮这个药，与胃它是起作用。如果这个，啊，咱们说这个宿食啊，啊，有的时候你只用大柴胡汤，现柴胡汤证，所以都治的。不现柴胡证，干脆就不必用柴胡，就是用调胃承气汤里加橘皮就行。那么大便，啊，大便不通，那么甚至于打嗝，啊，我们要是现大柴胡汤证，可以用大柴胡汤加橘皮。

大柴胡汤与葛根汤合方，这个与小柴胡汤和葛根汤合方一样的。这都是合病这一类的。那么也是在这个，啊，哮喘病里头挺多，这个我也用过，啊，也很好使。你比方说，我们方才说小柴胡汤加葛根汤，如果大便不通，舌黄苔，啊，这个心下部位拒摠，那你非…非…非通大便不可呀。那你就搁大柴胡汤合用葛根根汤就行，那么这个证与我们小柴胡加葛根汤这个主证差不多，啊，既有表证，又有半表半里证，同时又有里证。这么一种合病？这个病呀，一齐来。这一个在这个哮喘里头这一类的情况也很多。

大柴胡汤与桃仁承气汤的合方，就桃核承气了。桃核承气这个药是个祛瘀的药啊，这个方子用的机会挺多，挺多的，啊，就是有瘀血证。你像我们方才说这个热入血室。热入血室，他如果有其人如狂，你只是用小柴胡汤不行，啊。少腹这一块儿急结，这纯粹是瘀血证啊，你就得用大柴胡汤配合桃核承气汤。得有大柴胡汤证，这都是有柴胡证，这也很多很多的，啊。这一个不是，啊，只治一种病了。后头我们再把这几个方子说完了，再谈。

大柴胡汤桂枝茯苓丸合方。桂枝茯苓丸，那么这个，去这个，癥，啊，咱们《金匱要略》上说这个，啊，妇人有癥啊，就是常常的有这个血的积，血积，是吧？他用桂枝茯苓丸，不可下。但是这个桂枝茯苓丸与桃核承气汤啊，有些不同的地方。这个桃核承气汤有芒硝，那么这个桂枝茯苓丸里头呢，既没大黄也没芒硝。我们与大柴胡汤配伍只是有大黄，所以他没有谵语，啊，大便也不是那么样的干燥，我们一般就用桂枝茯苓丸。那么这一类呢？啊，你像那个桃核承气汤、桂枝茯苓丸。在什么病多呀？就是我们说脑血管、心血管的病，啊。以至于脑…脑系上的这个一系列的瘀血证的反应，都可以治，啊，这个很多很多的。那么如果口舌干燥也要加石膏。尤其这一个大柴胡桂枝茯苓丸这个合方，啊，我们治这个，这个心…心脏这种疾患，应用的机会多的很。也是我一个学生，他就拿这个，就是做一个心血管病的

一个常用的药，这个我不是我瞎说，好使得很。这一咱们临床上你们遇着这个，啊，这个冠心病很多。如果有心绞痛，这个方子更好使。血压高就可以加石膏，这个石膏…这个石膏，啊，对这个血压挺起作用。那么这一个在临床上遇着的挺多。像脑血管意外呀，也都可以使。那么其它的，你像这个出血，啊，有的时候都由于瘀血的关系，要现柴胡证也有用的机会。

大柴胡汤与牡丹皮汤合方，你看都是祛瘀的药，各个不一样。这个大黄牡丹皮汤啊，它没有桂枝。这个桂枝这个药啊，主要它治…要不桂枝汤能治头痛呢。在这个上边的病啊，大概都是桃核承气汤、桂枝茯苓丸，都是瘀血证。这个大黄牡丹皮汤就不然了，它没有桂枝，同时它有这个消痈肿的这个，现在我们就说流疮水了，有这一种，啊，它消痈肿，所以要有痈肿之便。这一种瘀血证都是要用大黄牡丹皮汤。咱们在这个《金匱》里头也讲了，所以治肠痈嘛，就是现在的阑尾炎啊。阑尾炎单独用大黄牡丹皮汤的机会少。也是以大柴胡汤的机会多，这一个通过临床就可以看出来。呃，啊，胸肋满，不吃东西，这是最普通的，你要合用这个大黄牡丹皮汤啊，那非常有效。这一个我治的例子也很多很多的。那么再有这个大黄牡丹皮汤合用大柴胡汤啊，不但治这个阑尾炎，也治胆囊炎，啊，胆囊炎，胰腺炎我都试验过。我方才说的，刘玉竹那个小孩子，他也得这一个病了，他那个胆啊，那个…那个…那个…肿的那个…拿手一摸都能摸着，挺厉害。他那个孩子叫小明嘛。就吃这个药，那快的很。他急性发作时候最好使。疼得怎么样子剧烈，尤其这个胸肋这个地方胀气呀，他都是显到胸肋满，胸肋痛，那都是柴胡证，很好很好使的，啊。我一个外甥，他胰腺这儿起一个，啊，起一个，现在也没确定，他是不是癌变？是不是其它的囊肿？据他们医院说是发生癌变。但是他这个病已经小一年子了。我就给他吃这个药，疼痛早消失了，他这个肿啊，也小的很多，从他这个吃药的这种结果恐怕不 像癌。那么这个大黄牡丹皮汤，它

起这个作用的。也是祛瘀药配合大柴胡汤，它与带桂枝这个不同，带桂枝这个脑系多。你像我们说这个脑震荡有瘀血的，啊，或者是脑系上，啊，由于有瘀血性的这种头痛也有啊，一会我们后头有，有这个例子。那你用大黄牡丹皮汤不行，非用桂枝不可。如果大便秘实的厉害，你得合用桃仁承气汤；如果，啊，里微实而没有潮热谵语等等的情况，你可以用桂枝茯苓丸。所以这个全…小柴胡汤有没这个情形？也有。所以我这个前后的加味呀，合方呀，错综这么搁，当然我在临床上这个体会是这样子，他小柴胡汤有瘀血证呢，你也可以这么应用，那没关系。这是说大柴胡汤，这个较比多，啊，我搁到这里了。

再就是，还有一大柴胡与茵陈蒿汤合方，这个也很多很多。咱们治这个黄疸呐，黄疸用茵陈蒿汤大家都知道，是吧？那么他有柴胡证，你光用茵陈蒿不行，要配合大柴胡汤。这茵陈蒿汤就是，啊，栀子、茵陈、大黄把这三个，由三个药组成。这一个很多。这一个我们治这个黄疸型的这个…急性传染性肝炎呐，那么发作这个的挺多挺多的，这一个也相当…啊，这都是我用过的，这个都相当有效。

那么对于大柴胡汤的加味呀，啊，就这么几下，或者合方，啊。这一个，等我们把这都讲完了，讲病例的时候，我都举…举些要紧的这个病例，大家都做个参考。

底下第三呐，我们研究看看这个柴胡桂枝干姜汤。这个方剂在这个临床的应用也挺广。那么这一个方剂，我们看起来呀，他没有半夏，啊，所以他不治呕。那么在这个书上呢，也是不呕而渴。他这栝蒌牡蛎散这是个方剂呀，你看那个…那个《金匱要略》就有，栝蒌牡蛎散呐，它是这个治渴。那么不呕而渴的柴胡证，啊，那么现这个方剂的很多。这个方剂同时呢，它有桂枝、甘草，心悸气上冲，是吧？这个气上冲啊，常常的这一个水伴气往上，不往下，小便不利。这一个栝蒌配合牡蛎，不但止渴，他也治里面的微结，所以这一个方剂呀，需要大便偏干，不治大便秘，里头有微结，他没显出来大柴胡汤那个心下急那

个样子。但是大便偏干。咱们说这个栝蒌根跟那个栝蒌啊，它有共同之点，但是它是一个滋阴解渴，那栝蒌也有一点，那栝蒌有点缓下作用，这栝蒌根也有一些。栝蒌根是苦寒呐，啊，那么它也解渴，它表现的特殊。所以这一个方子，如果柴胡证不呕，它特殊，而渴，那么如果心下，这病人呐，感觉有所结滞，但是不像那个大柴胡汤那个厉害，说有微结，我们可以用这个方子。再有气上冲啊，啊，或者心悸呀，都可以用的。这个方子我们根据药物分析呀。在临床上应用呢，挺特别，因为很多的这种的这个顽固低烧，现这个方子的很多，可也是根据这一种情况，有柴胡证，啊，渴、特别无力。这个栝蒌根这个药啊，它是强壮性的一种滋…滋润药，它起强壮作用。我们小柴胡汤，啊，就感觉疲倦无力，这个柴胡桂姜汤啊，更疲倦无力。我们常遇着这个肝炎患者就知道了，他特别疲倦无力，啊，甚至于肩背痛，他就是桂枝的关系了。有些这个，咱们说这个，啊，西医这种诊断叫无名低烧啊，用柴胡桂姜汤的机会很多。而这一个方剂呢，由于它是多少有点补虚的作用，啊，身上无力，啊，较比突出嘛。所以对于慢性的疾病最多见，一般慢性的疾病，啊，最多见。但是他…他胃并不坏，所以大便还偏干嘛，他要偏稀还不行这个…这个方子，啊。所以它不用人参。这个书里头啊，就这么一节儿我们可以介绍一下。“伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也。柴胡桂枝干姜汤主之”。那么也是伤寒五六日的时候，啊。这个病已由表传入半表半里。那么在这以前，已经发汗，而且还给吃了泻药了。那么这个五六日的时候就传到少阳而发生柴胡证了，所以这一种发汗和这个泻药，这都是逆治啊，治错了。可是这个病人呐，胸胁满没去，啊，而且微结。他由于吃泻药，所以引邪入内了，里头稍稍有所微结。由于气上冲，那么小便不利于下，是吧？也这是两种：一种这一个误汗，误下，津液亏，也影响小便不利；那么再气上冲呢，它更影响小便不利。由于津液亏，

啊，所以他渴，但是胃没有停水，他不呕，啊。那么头汗出呢，也是气上冲的关系了，啊。他这个热伴着气上冲往上不往下，所以但头汗出。往来寒热还柴胡证啊，啊，心烦易怒，啊，这都是柴胡证。往来寒热，心烦，胸胁满，柴胡证俱在。但是主要的他是不呕而渴。他不是用一般的柴胡证，啊，得用柴胡桂姜。那么就这么一段，可是根据临床的我们体会呢，这个方子就我方才所说的这个。主要呢，他柴胡证，不呕而渴，病人呐，感觉有点这个，啊，自觉证的结滞，啊，就是这个心下部…啊。同时，特别感觉身躯无力。那么就用这个方子，主要的一个证候。那么这个方子我们最常用的全是一个慢性疾患。尤其我们治这个肝炎呐。我常用这个方子。慢性肝炎，就是用柴胡桂姜汤合用当归芍药散。这个当归芍药散呐，你像这一类的药，这个当归和这个芍药这个药，芍药就是川芎了，也是祛瘀药，咱们一般都说它补血了。其实它的……（音频缺如）……能利用当归、川芎这类的药，就不要用桃仁、丹皮呀，或者水蛭、虻虫呀，那一类的药，它也祛瘀。那么这个我们在这个临床上有的是呀，你看那个温经汤，它那里头四物，一吃那个一样儿下血快，它也祛瘀嘛。不过他这个虚证，你得用强壮性儿的祛瘀药。我们这个慢性肝炎呐，也是的。他里头有瘀血，但是人虚，你就不适于我们上边那一种方剂，桃核承气汤啊，桂枝茯苓丸呐，大黄牡丹皮汤全不行。你就要用这种这个强壮性的祛瘀活血药，就是一般我们常用当归芍药散，啊。当归芍药散就是芍药、当归、川芎、啊，茯苓、术、泽泻就这么几个药。这个最常用，不只是，啊，我随便说一个慢性肝炎呐。不只慢性肝炎，凡…就我方才说的那个低烧，我用这个方子还治低烧呢。他既有柴胡桂姜汤证，又有咱们说的这个贫血性的这一种瘀血证，啊。他贫血自管有瘀血呀。那不在他这个贫血就不能有瘀血了，是吧？啊。就是虚，现这么一种，啊，虚型的这么一种瘀血证，你就可以用。那么这个方子用这个，你像我们慢性肾炎呐，慢性肝炎呐，都有这个方子这个；还有这种这个身上疼痛

啊，找不出个所以然来，但是确有瘀血证，你无论看他，啊，也兴有这个瘀斑呐，啊！咱们这个瘀血证很多了，喜忘，啊，啊，当然是，这一类的这个虚…虚衰的这种瘀血证呀，没有发狂啊，你像我们用那个桃核承气那一种证候他没有，他也现着一种啊，虚衰的一种反应。精神不正常，啊，他就是不发疯。那么也有在妇女这个经血不调，啊，由于这个发生身上这个，血虚型的一种疼痛，也有的，也可以用。所以这个应用的范围也很广的很广的。那么一般那个，我们就是用拿它治这个慢性肝炎呐，或者慢性肾炎，都有这种情况，啊。他腰…腰疼，尤其腿软，啊，胸胁满，那么他不呕，渴，心下这个地方啊，也觉着发…发闷，啊，他没有一个特殊，摠着当然不痛，他不是有所实，那实到那个分气上，不是的。特殊的表现“疲乏无力”。那么大便如果偏干，就可以吃这个。我们治慢性肝炎这一个方剂呢，在这个临床上最常见。那么如果是…啊，肝功能不好，可以再加上丹参、茵陈，啊。丹参量不过要大一点，它也是个…也是个，共这个…所以丹参能代替四物嘛，它也是祛瘀血的药。这个茵陈呐，这个茵陈这个药啊，有一些人都知道它是利胆了，它祛湿热的。这个肝胆它是为表里了。有的时候肝炎、肝功能呢，啊，破坏的特别厉害，你一搁这个利胆的药反倒…啊，反倒有效。就我根据临床啊，一般的肝炎见这个证候最多。那么如果这个胁痛的厉害呢，可以加上王不留。就是王不留行啊。这个王不留行这个药本来外科用，是吧？它是这个祛瘀定痛，所以对于肝区疼，有时用它好，但时呢，也是利于虚寒，不利于实热，这个东西。它是个温性药。那么在柴胡桂姜汤，那么其它的这个加味、合方，常常以上。也有…你像这个，啊，加石膏啊，也可以，他口舌干燥也可以加，啊。你像加这个，啊，有些这个，他要哕逆 的情形呢，啊，那么可是渴，也可以加橘皮嘛，啊。这个头前儿讲过的，这个后头就不要往里头搁了。

第四个就是四逆散，我们最后讲这个方剂。那么这个方剂在《伤

寒论》上…提出来一段呐，与我们…与实际这个临床应用啊，颇不相符。那么这一个就是柴胡、芍药、枳实、甘草这四味药。他古人本来他用散呐，就是面子药啊。我们现在呢，拿它做汤剂。汤剂就把这四味药啊，9克以上，啊，9克到12克吧，就…就行，做煎剂，我现在净拿它做煎剂。这个药应用的机会倒是挺多。我们看看那个书上怎么说的，在《伤寒论》里有这么一种…这么一段说，少阴病，四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。他列到少阴篇里头了。那么为什么呢？这个…这个虚寒的证候啊，经常有四肢逆厥。可是这一个方子你们看一看，柴胡、芍药、枳实、甘草。哪一个也不是，啊，治虚寒的。所以这一个厥逆也是热厥，而非寒厥。那么这个热在这个，这个柴胡它治胸胁，啊，所以胸胁这个地方呀，郁热太甚，影响到这个血液，啊，血液有点受阻，也影响到这个四肢厥逆，属于热厥之类。当然热厥它不是少阴病啊。仲景这个书啊，他常常是这样子，他让你鉴别，形是少阴，实不是少阴，它应在少阳。那么在通过临床这类四逆我还没见着过。这个四逆散治四逆的这个，啊，这个实在的情况不多见，反倒以这个其它的这个他底下有些或然的兼证，到是不少。你像这个治咳嗽啊、治下利呀，这个四逆散治下利。我们头前儿讲那个大柴胡汤证，这一个大柴胡汤证不可下，而不呕，可以用，它也有枳实，芍药，心下这个地方发闭塞。那么这个地方发闭塞，而有柴胡证，主要的他是胸胁满了，啊。有这个证候“不可下”，里无实就是，大概都用四逆散。所以这个方子应用的机会并不少，啊。那么我们一般用，单独用这个方机会也不太多。也都是合方，啊，或者是加味。我们常用的这个旁的加味还是参考以前，这都是一个，…与这一个方子特别常用的加味我就介绍。

四逆散加龙骨牡蛎，这一个方子，啊，用的挺有意思。就是在这个四逆散呐，龙骨、牡蛎各加12克。这个龙骨牡蛎咱们都知道，是吧？在这个《伤寒论》里常治这个“惊狂”啊，啊。那么历来对这个

龙骨、牡蛎的认识呢，也不一样。有说它是，啊，收敛固精呀，究其实它是对这个，啊，精神不正常。咱们说这个胸腹这个地方，悸动，啊，人的这个发惊，啊，发恐惧，这全是龙骨牡蛎证。所以古人对于这个遗精什么的，他都用龙骨、牡蛎。他这一类的病啊，都由于神经的关系。那么我这一个方子，就是四逆散加龙骨牡蛎，不是治遗精，它能治什么呢？咱们就说这个，这一个临床上也很常见的，说这种痿证，就是阳痿，这个挺好使，这个你们可以试验。它这个四逆散呐，它主要的，它是一个舒畅这个胸胁这个地方，啊。那么它与肝是有关系了，拿中医观点呐。所以这个肝主筋，啊，这个肝气畅动啊，如果再加上治神经，那么这一个与神经是有关系。我对这个…个人的看法不一定是对的，啊，加龙骨牡蛎，这个我治，也治些病例，啊，挺好使。这一个在头前儿就没有的，是吧？这个在这个地方。那么古人说这个龙骨、牡蛎治三惊呀，就是害怕那个惊，啊。

那么四逆散呢？那些这个祛瘀药也可以…桂枝茯苓丸什么都可以用的，啊。这一个不详细说了，假设四逆散证有瘀血证也可以这么加。那么最常用的我们就是加这个当归芍药散，这个…这个…这个，方才所说的这个。它加上桂枝茯苓丸呐，也挺多，这个四逆散加桂枝茯苓丸后世有一个方子，很相似，就血府逐瘀汤嘛。这是王清任的方子，我也用过这个方子治过类似的病。如果四逆散加桂枝茯苓丸再加红花呀，啊，那与他这个方子差不多了，加牛膝，是吧？但是不必那样子瞎加，就搁桂枝茯苓丸就行。咱们说是这个血府逐瘀汤的这个应用啊，可以用四逆散加桂枝茯苓丸。

我们最常用它合用当归芍药散。这个四逆散就治…这个四逆散里头你们细细琢磨，它有这么几种药，枳实芍药散，芍药甘草汤，你看这个，这个方子非常小啊，它包涵的东西不少。它里头有枳实、芍药，它就包涵了枳实芍药散了。这个枳实芍药散治腹痛，啊。所以产后腹中痛，啊，应该吃枳实芍药散，它这个行气，啊，行气也活血。这芍

药甘草汤更知道了，是吧？那么至于这个腿软，古人这…这两味药他叫做去杖汤嘛。腿疼不得拄着拐棍儿嘛。啊，这个药可以去拐棍儿，啊。其实它是对这于下肢的病常用这个芍药甘草汤，同时也治肚子痛。这个当归芍药散也治腹痛啊，那么如果腹痛心下闭塞，啊，有柴胡证，用这个方子啊，你当然一般不用当归芍药散就不同了，他有柴胡证的话，你用当归芍药散就不一样了。那么什么病有这一种方剂的这一种反应呢？我们说这个，头前讲那个大柴胡汤与这个大黄牡丹皮汤，治阑尾炎不是嘛。那么如果慢性，不是在急性的，啊，没有那么热象，也有柴胡证，大致啊，都是这个四逆散与当归芍药散合方。不过当归、川芎温性药不要用的太重，都搁6克就行。这一个我也是在这个实践上体会的，啊。那么顶好呢，要加这个…这个薏仁米，薏仁米这个药啊，它有排脓的作用，加上这个陈久性的这种阑尾炎，它有些化脓的机转，但是不显，而腹痛，啊，经常的那嗤嗤拉拉疼，这个四逆散合用当归芍药汤正好治，这个我用过，啊。那么再有呢，就是说慢性肝炎这一类的，慢性肝炎我们头前儿有一个，是吧？柴胡桂姜汤当归芍药散，那一个是偏于治大便干，这一个呢，偏于治大便稀。你看看这个，啊，或下利，他这个，这个四逆散就能治下利，假设我们遇着这种肝炎，啊，他心下这个地方闭塞，有柴胡证，大便偏稀，你用柴胡桂姜汤就不行，所以这个，这个用药这东西差一点儿也不行，啊。越吃大便越稀。你就用这个四逆散这个为主药，配合当归芍药散，那么跟它其它加减一样了，肝区疼也可以加王不留，是吧？肝功能破坏的，啊，厉害的也可以加丹参、茵陈，那都一样。这是我们治肝炎呐，这么两套方剂。

那么如果这个胃的疾患明显，他下利嘛，啊，他是大便偏溏。那如果他再有不爱吃东西，打嗝，你这个方子啊，也可以合用这个茯苓饮这一类的。茯苓饮这个方子啊，就是橘皮、人参、生姜、茯苓、苍术，啊，有人参。那我们现在就搁…现在用这个党参就行了。就这六

味药：橘皮、人参、生姜、苓、术。茯苓，搁白术也行，苍术也行。我净常搁苍术，啊。那么就是，啊，枳实，枳实咱们这个四逆散有了，不必搁了，啊。就搁 这几味药就行，是不是？这茯苓饮呐，在《金匱》里头也有。它是外台上的方子。就是消痰气、令能食。人不爱吃东西，打嗝儿，啊。那么他这个胃里头多少有停水，所以他大便也稀。那么总而言之，这个四逆散配伍这一种药，偏于胃肠疾患的多。这个肝炎的疾患呀，常常有胃肠疾患。所以胃肠疾患多，我们用四逆散的配合当归芍药散的机会多。否则，疲倦无力的方面明显，那就是柴胡桂姜汤当归芍药散的机会多。这就是治肝炎的体会，啊。这么两套方剂。当然其它的还有了。还有了，啊，比较少见。这两个都较比多。今天咱们特意介绍这…把这个介绍到这个地方。

底下呀，有些这个治例，啊，挑要紧的我举几个，大家，啊，听一听做个参考。

那么关于治这个…由这个…治这个感冒发高烧的这一类的，啊，这一类的病例我来谈。那么有一个人呐，啊，感冒发高烧。也经过注射，啊，也经过吃其它的药。当然是表解了。就是这个烧不退。这个得这个病没有几天。他的舅舅啊，也来旁边儿着看他，他的舅舅也知药，也知道，啊…也会治病。但是烧不退。后来呀，他们找我会诊，啊， 他这个脉呀，就是浮细，数急。脉浮细也快，发热头痛，啊，呕不能食，这就那个小柴胡加石膏汤证，所以就吃这个药，吃了就好，这个…这个方剂用不了吃几付药，大概一剂两剂就可以好，这个较比轻。那么还有一个，啊，这是我一个亲戚。他是这个，是个工程师，他平时啊，他不信中医，他更不喜欢吃中药，他也是开始是感冒，啊，发烧。他那一阵儿他净，净去协和。吃些西药，啊，但是他这烧啊，比较是减了。可是头痛如裂，脑袋疼的呀，叫，那个时候他才三十…三十多岁年纪。那么一个壮小伙子疼的直哭。后来要给他抽骨髓，他不干了，那个大概协和医院呢，一个他是怕他是脑炎，给他抽脊髓呀，

他不抽，啊，他就后来没办法了他找我。当时他这个情形呀，脉弦数，啊、胸胁满、心烦，啊，口舌干、头痛他自己忍不住，也是与小柴胡加石膏，我们方才讲那个加石膏的这些或者头痛如裂了，这是一个，这个也挺多挺多的，那么他吃了药就好了。后来，他现在有病他找我了。他也信中医了。还有就是这个，啊，这个肺炎。我方才说的这个小柴胡加石膏治肺炎嘛。咱们有几个同学，大概老的人能知道，有个叫吴国平的，现在这人在新疆的吧。他在咱们这儿住院的时候得肺炎。我给他看的时候啊，就是三四天的时候，那个时候啊，身热汗出。他盖个毛巾被，我到那里给他看，好，那真是蒸蒸发热，胸胁满，啊，干呕，不吃东西。那个时候，对于他的病负责任呢，也是一个老大夫。我就给…我就说，我就给他开小柴胡加石膏。他说不行，我给他用这个药了，我说你怎么用的？他柴胡开了四钱，啊，四钱才十二克了，石膏用了一两半，我说不行，我说他这么样子热，你那么用哪行呢？我说不是你药错了，分量不对头。当时我给他开啊，这个石膏大概不是三两就是二两啊，啊。柴胡开二十四克，吃了就好了，就是当年那个同学。所以这个，这个治病啊，分量不对头也不行。那么他就是很快就出院了。还有一个小孩也是得这个肺炎，啊。这一个，这是空军医院的，我出去会诊去，这个孩子的姓儿我是记不得了。不过那个岁数是七八岁。那是已经都晚了，十点钟了。他那个，那个中医大夫是我的学生，他就来了找我来了。找我来了我逆烦呐。你看他是…我都要睡觉了，我说这时候你怎么找我会诊呢，唉，你不知道，这个病特别重，他那个时候那个，那就是想推诿了。他这西医呀，已经把把这个病号送出来了，让中医治。中医吃药也越吃越…越遭，他这个院长害怕了，他说这要死了咱没…没请人家会诊，起码没请中医会诊呐，是吧？所以说你去，这个人呢，我那个学生，他要明天来找我来。他说你别等明天，这个病还等明天，你今天去吧，他就来了。他跟我说这个情形，我也磨不开，我就去了。去了这个孩子啊，在我治的这个

肺炎这是最重了，他那个得病啊，啊，光昏迷就是三四天，人事不醒，那吃东西，什么也…滴水不入。那就像个死孩子一样啊。那么我看他这个方子他开的是麻杏石甘汤，我说不行了。他那个…他那个眼不睁，啊，口不开的，这么一种情景，就听他这个…这个呼吸呀，嘶拉嘶拉的这个嘶鸣，就是痰鸣啊，就是这个。我说这你还给吃发汗药呀？不行了。当时我给他也用的小柴胡加石膏，我石膏用了四两，这是最多的时候了，啊。小柴胡汤是原方那么用。我告诉他，我也不敢一次让他吃下去。我说这个一宿把这一付药吃净。频服，他那得灌了，他不会吃药了，就拿那个调羹啊，就是往里头灌。我说你别一回给他灌多了，我说这一宿，两煎吃净。我说我看这个病也是危险。他就这么样子给他用下去，用下去了，以后来呀，也有一两个月，他也没给我信儿，我寻思这孩子死了，是吧？后来他又找我会诊，治旁的病。那一阵儿这空军医院我每个礼拜大概都要去呀。这时候去了，我想起这个孩子来了，哎呀。我说那孩子，你老没说，他是不是死了？他说你放心，可好了。他说就吃那个药，啊。他说逐渐的好，他说我也没改方子。我也老是这么办，一直出院，好的倒是挺快。这在我治病，这一个肺炎呐，这个是最重不过了，啊。所以我…今天我举这个例子都是较比重的，重要的例子，值得…值得参考的。还有我们头前儿说这个治下利，啊。也有那么一个人，他是个商人。以前这个前门外这个观音寺街这个口儿有个“天得和”的这么一个布店。他兄弟和我挺好，他我不认识，这人姓风。他得这个病也挺…也是用这个方子和他这个病的治疗也挺奇怪，就是为禁口痢。什么叫禁口痢呀？吃就吐，而下利无度，啊。这一天呐，就是老拉。那么这一类的病啊。那一阵儿我也是反复的想，不敢吃泻药。可有里急后重，因为那个呕太厉害了。所以呕多者，啊，你这个吃泻药是危险的。那一阵儿也有位大夫主张吃承气汤，我没听，我就给他开的小柴胡加石膏。吃完就好了……（音频 044 完）

关于学好经方的认识

李冠杰：首先，经方难学还是好学？客观地说，经方比较难学，主要集中在两方面：

第一，学《康平本》就能清楚感觉出来，历代注家都是用经方以外的理论来解释经方，人为地给正确学习经方设置了许多障碍，我们要把这些东西都剔除掉。实际上现在也没必要把顶格条文全提出来，这样也不客观，因为有些其他条文也有精华，我们从古人继承的就这么点东西，再去删改也没必要，正确理解才是最重要的。刘渡舟先生深有体会地说“《伤寒论》这堵墙很厚”，实际这就是人为的障碍，而且他学了一辈子也没真正逾越过这些障碍，这就是个很生动的小实例，也是个很残酷的现实，因为自从这本书从张仲景手里出来后，就再也没有人真正、正确地读懂过。这种说法是从我们掌握的史料中所能了解到的，站到今天的角度看，直到建国前后才出了一个胡希恕先生。胡老用毕生的精力还经方一个本来面目，这也是胡希恕思想的价值所在，两千多年的历史里才迈出了实质性的一步。所以说难是真的很难，但反过来看，现在我们有胡希恕思想做指导，学习就容易多了，不用耗费半生甚至一生的精力，只要学习方法正确，几年时间就可以基本掌握经方的精髓。

第二，经方开始学的时候非常简单。这有点像说相声，说相声门槛很低，任何人都可以进这个房间，但进来以后想要说好，里面的台阶高着呢！经方也是这样，初看太简单了，特别是主要条文就前边是症状后边是方剂，方剂和症状相应，在方证和症状之间划一个等号的这样一本书。而且常会出现初次用几个方子还会用，有时还能起到意想不到的疗效，让人感觉经方的门槛很低，但实际上经方是很深奥的医学，所有的经方理论用现代的科学手段还没法证实。所以经方是个

彻头彻尾的经验医学，是个暗箱理论。比如小柴胡汤治小柴胡汤证，表现的四大主证，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕。这四大主证，不同的人站在不同的学术观点以及不同的角度甚至不同的知识结构上给出的解释就有所不同，因为没有一个是当作标本的解释。经方医学（包括传统中医）有上述这样的特点，因为真正解释不了就等于是理解，不理解就不会用。那非要去理解，非要去解释，这就势必会出现众说纷纭的情况。这与西医不一样，西医有些东西明明在临床中验证是错的，但数据在那儿摆着，也要那么去讲究，考试也按照那个答就对了，而且整个理论都是按照这个来的，等有朝一日自己证明错了，自己会去修正。所以学经方学来学去总有徘徊和迷茫的时候，真正走进来是一个挺难的事儿。我们从顶格条文就能看出作者的高明，条文不论理的原因就在这儿。假如论理的话，有很多情况就无法解释，因为用今天的学术观点看顶格条文也不是百分之百都正确，也有错的地方，就是由于背景不同、历史环境不同造成的。经方的一些具体问题也是这样，经方的精髓是方和证相应。方剂的适应症不是一个固定的症状群，而是一个动态的。像小柴胡汤四大主证但见一证便是，当然不是这么机械，但这种论述也没有错，在没有其他疾病时真是四大主证但见一证就是，没有稳定性，没有一个在临床中很具体的、可以拿来套用的指标。但西医有化验指标，血小板是多少，血压是多少，尿糖是多少等等，经方没有这些，都是动态的。另外，方证和方证之间的症状很多都是交错的。比如发热在六大类疾病中都有可能出现，临床运用时就要深入去学习和理解，最后形成会用经方的一种个人的知识环境。以上是说经方难的两个比较突出的特点。

我常说的一句话：现在学经方就要学会站在巨人的肩上。因为胡老的学术思想给我们不单树立了一面旗帜，也为我们的前进指明了方向。学胡老的学术思想就等于站在巨人的肩上，他用一生的精力把自己塑造成了经方的巨人，我们可以沿着他的路去理解他的学术思想。

理论方面胡老与其他学术思想不一样的地方先不说，就说胡老的临床效果，在临床中他用经方是最纯的，疗效也是最好的，仅凭这一点我们就没必要再另寻其他的路径，其他的只能做参考。因为胡老自身的临床实践已经证明这是一条正确的路，多难多徘徊都应该沿着这条路走下去。所以在学习经方的过程中，应时刻记住两个问题：

一个问题是，为什么经方经历了两千多年才出了一个胡希恕先生？这是一个最基本的问题。我们仔细研究和分析胡希恕先生经方的成长道路，就会发现这既有历史的必然性，也有胡老个人的偶然性。胡老从十几岁上学老师教给他经方理论的时候，读这本书一开始入门就不是脏腑辨证，这一点很重要。这说明在整个经方的传承中有极少一部分人是不搞脏腑辨证的，他们基本上是读懂了经方的内涵，但却成不了中医的主流。因为在胡老的书出版之前，一本这样的书都没有，但并不是一个读懂的人都没有，这是我们必须时刻牢记的问题，只有这样你的方向就不会轻易被其他学术观点吸引过去。

另外一个，中医的整体疗效很差，这是一个不容回避的问题。中医的出路只有经方，我们可以说得狭隘一点，只有胡希恕学术思想的普及推广，才有可能给中医闯出一条生路来。否则中医也就跟京剧国粹是一样的了，慢慢自己就进了博物馆陈列品的角色了。我们必须牢记，这是一个基本点。很多人一开始学经方都热情很高，学一段时间后逐渐又去学时方了，这很不可思议，但这是现实。而且这些跳出胡希恕学术思想范畴再重新学时方的人，常常都是高智商的、事业有成、出人头地。为什么会出现这种情况？就是忽视了一个问题。因为随便拿一个时方医生的医案看看，有时能看得热血沸腾，但要冷静地分析假如治病的疗效真的很好，那为什么中医整体的疗效那么差？他走的那条路恰恰就是很多人都在走而走不通的路，所以最终的结果就是糟蹋自己的时间和生命。以上是学习经方应时刻注意的两个基本点。

下面我们再看看学好经方应该注意什么？

首先一个就是反复学习、坚持不懈。这点前人给我们留下了很多经验。在学经方的过程中接触最多的就是背诵条文，但这并不是一个好的学习方法。因为背条文的最高境界就是把所有条文都背过了，而同样面临着一个理解的问题，最后理解不了，背过条文本身就成了包袱，都已经倒背如流了但还是用不了，这门学问不行，就坚持不下去了。这并不是危言耸听，很多人能把《内经》、《伤寒论》、《金匱要略》背下来，这样走过来的人太多了，但依然不会治病，没用的。然而，坚持下去反复学习也是我们必须走的唯一道路。胡老就给我们做了一个非常好的榜样，冯老在整理胡老遗留的手稿时就发现了一个问题，胡老反复地抄这些条文干啥？实际这就是胡老在不同时期从不同角度去分析理解同一个条文的做法，那时没电脑就用手抄，既加深记忆，也可以从不同角度把相关条文再去合并到一块儿，去比较它们有什么样的差别。总之，胡老就是反复的在学，从十几岁到八十几岁，一坚持就是六十多年。

另外一个，学习方法也很重要。光是反复学也不行，我就曾经遇到过这个问题。一开始接触胡老的东西时，我就眼前一亮，要找的就是这个。我当时徘徊得很厉害，谁能给我把《伤寒论》的道理说清楚，那就开始投入进去学。学第一遍很快，到第二遍时对六经突然就有了自己的想法，以前学的六经就认为是经络，太阳经是身上循行最长的经络，觉得非常有道理，但学了胡老后感觉不是那么回事，这是一个突破点。但突破以后就面临着一些问题，怎么再往下学？我就开始想一些办法，后来在每一遍学习都带着一种任务去学，一遍一遍地看胡老这两本书。我还在不断地整理资料，比如整理的胡希恕讲药，就建一个文件夹“经方与药”；讲桂枝的，就把所有胡老讲桂枝的内容都摘录下来放到“桂枝”的目录下等等，就这样把所有的药都弄了一遍，但从整理完就没再看过一次，这也是事实，但那时觉得这个用处太大了。胡老也说过想写一本关于药的书，但时间来不及了他没写。后来

还整理病和方证，胡老这两本七十多万字的书我大概读了不下十遍，最起码在七八遍里都是带着某种任务去读的，这是一种学习的方法。

用我走过的路来说，这个方法对学习非常有用，但当初的愿望却没达到。因为当初在整理时就想假如以后要找资料时，打开整理的不就是吗，结果整理完以后实际再看的机会非常少，真正看得多的还是原文。但整理的过程非常有价值，可以加深印象和理解，真正的意义在于整理的过程，而不是最后整理的结果。后来我还在想，胡老这两本书是个口语式的讲稿，这么好的东西整理成书面化的不行吗？我试着整理过，难度太大了。再退一步，写体会或读书笔记行吗？真写的时候才发现很难写出实质性的东西，这倒不是说胡老的东西高得让人一点想法都没有，而是你在读的过程中有一些理解和想法一闪而过，逐渐地这些东西形成了你的一个知识结构，但真要把这些东西系统起来时，你还真没做过。这是另一个层面。

再到最后就是跟大家一块儿学习，我要带着大家学习，要把所有问题的方方面面都得想到，最终得是一个完整的意思拿出来，而不是我感兴趣的我就去学，不感兴趣的就不学，那是不行的。这又往前推动了一大步，就是我们在学習时应该想着办法去学習，千万不要用一种方式。就跟读书一样，读了三四遍以后就没兴趣再读下去了。但我读胡老这些东西，到现在看起来有时还觉得跟看第一遍一样，这实际就是理解的深度不一样了。反过来，真要是不用心地去学，不深入地理解，那就要止步了，这是很危险，就很可能半途而废了。这是在学习方法方面我自己的体会。

另外一个，就是学习经方要有独立思考的精神，千万不要人云亦云，要有实事求是的态度。我在学习经方方面，把经方临床方证资料 and 现代应用资料与条文的内容串起来并接轨，这是我做得比较用心，也有一点效果的事。因为我自己对这些数字的资料有一些敏感，能加深理解。学习经方我们回到问题的最起点，为什么要独立思考？有些

时候先到问题的起点去想一想。经方这本书的精髓是在两千多年以前就建立起的一整套理论体系，这样一个体系不管作者是谁，也不管是哪些条文的内容，如果说经历了这么长时间后依然是完美的，这不合乎逻辑，也不是事实，若是存在某些不正确或不到位的东西，这才是客观现实。所以在中医里就有一种倾向，学中医经典要全盘接受，理解不了也要强理解、强接受，解释不了拐着弯也要去强解释，也要去歌颂。这样完全没有必要，要独立去思考，对的就是对的。当时理解上有误也没有关系，可以把它放在心里，得出来的结论跟别人不一样，再去找别的依据，这个结论能不能得到临床实践的支持，能不能得到逻辑推理的支持。现在胡老已经给我们奠定了一个非常好的基础了，我们应该是在这方面轻松多了，这也是一个基本点。

要是想独立思考问题就必须养成一个素质，不要片面地思考问题，哪怕是得出一个很小的结论，都要把问题的方方面面想一遍，从各种角度去审视，最终才能总结。比如有人说要学中医必须学金元四大家，但也有人说金元四大家是糟蹋中医的罪魁祸首，为什么差距会这么大？我们应该全面地去看，恐怕这两种说法都有问题。对待经方也应该全面地看，凡是有争议的东西你应该自己去追根求源。胡老有一些现成的东西给了我们，我们拿过来再和别人的东西比较，你会发现胡老解释的东西还是经得起推敲的。

学习经方还有一点就是自己亲身体验，这也很重要。另外就是结合临床实践，对于有临床环境和没有临床环境的人来说，自己亲身体验都非常重要。怎么亲身体验呢？经方讲究方证相应，没有症状要怎么去体验呢？你不要这么去想，现在来我这儿一块学习的朋友不吃我的药的少。前段时间青岛一个学生过来，看他身体还行，问诊、摸脉后一大堆的毛病，我给他弄了大概是四五个方子的合方让他吃，上午吃了下午就挺好，然后就走了。实际上没有哪一个人是一点病理倾向都没有，越是没有明显的疾病，越能锻炼辨证能力，总能从蛛丝马迹

中找到你自身的一些病理倾向和方证的依据。假设你真是一点病没有，也没什么症状，我建议你偶尔喝一次小柴胡汤。你喝了就会有感觉，而且会感觉非常舒服，实际上你这就是有病，连着喝上几天可能会感觉有别的变化。这就是亲身体验，有许多东西从临床中是体悟不到的，病人也给你说不了，只有在自己身上亲身体验。但我们也不提倡盲目试药。好多年前我试四逆汤用 90 克附子，熬一付喝下去就体验附子中毒，你们没必要去冒这个险。这也是一种思路，你有机会试一试、喝一喝中药。我看到有中医博士临床好多年，自己从来没吃过中药，真是有点不可思议，这种看病就很难保证疗效，这也是一方面。

另外人的健康问题也很重要，这也是个高难度的问题，现代社会人人关注健康，人人想获得健康，但最终的结果是人人不健康。我在学经方的过程中自己感悟出了对健康的一套理念和方法，确实管用，以后找时间专门和大家聊聊有关健康的问题。这个意义在哪儿？前段时间一个中医大师跑到其他没有他名气大的医生那去吃人家药，他关节不好吃别人的药，这背后有什么问题？这说明他自己关节不好自己治不了，自己有病自己都治不好，那能保证治好别人吗？别人跟你的病一样呢？你要碰到这样的病人，那不就治不了嘛。再一个你自己都不能健康，说明你对人的生理、病理等方面的认识还不到位，否则就应该知道怎么让自己健康。所以自身的健康对于一个中医来说是非常重要的，而且也太实惠了，自己健康是花多少钱也买不来。（完）

后记：

康平本伤寒论讲稿学习心得体会

袁洪雷：

一. 讲稿初接触

2018 年 11 月份，由于自己制作了一些散剂，例如：茯苓饮、四逆散、下瘀血汤、肾气散；这些散剂是独立包装卖给患者的，也不贵 70 元，140 克，患者可以服用 2 周，比较受到患者欢迎，但是自己总觉得不太满意，这个时候上网搜索散剂的时候，找到了董洪坦师兄发布的文章《李冠杰医案解析》，这篇文章中提到的疗效、病例格式、散剂的优越性一下子就吸引了我，我想这不就是我一直以来探索的方向嘛，于是在董师兄的帮助下，拿到了李老师的手机号。2018 年 11 月 18 日下午五点半，我怀着忐忑不安的心情，拨通了李老师的电话，李老师声音洪亮，知无不言言无不尽，当得知我对老师的体系感兴趣时，问我想要什么资料，我不好意思地说想学习您的所有的文字资料，当时觉得自己是不是有点过分了，这要是换做别人可能都会把自己的宝贵经验深锁金匮的，没想到老师居然满口答应，第二天就把讲稿、条文方证对应整理、医案还有各种疾病的对应方剂、经方病理整理全都无私无偿的发给了我，我当时非常感动，截止到现在首次得遇如此无私之恩师，实乃三生有幸！！！也因此定下了我们团队平台的宗旨那就是：无私、无偿、无悔、无惧，弘扬经方，造福人类！

在老师的指导下，开始了康平本伤寒论讲稿的学习，当时我看的讲稿是从呱呱讲课转换成的文字版，大约 140 多万字，里面有很多重复的词句，为了跟上老师的讲解，我开始了疯狂的阅读，每天拿着笔记本电脑，吃饭、睡觉都在浏览讲稿，花费了半个多月的时间把讲稿浏览了一遍，当时真的是如同饥饿的人扑在了面包上，那种读书的收获真的是醍醐灌顶、沐浴暖阳的感受，当时刚学完胡老、冯老的经方医学体系，正是满脑袋问号的时候，这下子全都有了满意的解答，从胡老体系，到李老师经方病理辨证体系全都通透了，怎一个“爽”字了得，读完后开始想，这么好的东西怎么能这么粗糙呢，得需要精简，于是第二遍阅读时开始进行讲稿的修订，改正错别字，去掉重复内容，

进行删减，到第四遍的时候，形成了讲稿的修订版，共计 127 万字，后来，刘登勇、陈贵石、郭明、曲涛师兄联合几位师兄师姐组成了讲稿修订小组，经过大家的努力，形成了 91 万字的《康平本讲稿 2020 修订版》，这个版本就是大家目前自行打印的版本。

二. 四次整理的不同收获

第一次的任务，把讲稿中涉及到的经方、方剂的解读，李老师搜集到的该方的统计资料包括症状、舌质、现代疾病的所有内容汇总到一起，制作成了方证分析，后经郭明师兄、汪阳师兄进一步完善添加目录，形成了《病理辨证体系版方证分析带目录》方便大家学习查询，自己在整理的过程中，对方剂的认识进一步加深，也帮助自己在临床当中使用方剂时可以做到从容不迫。

第二次任务是，把讲稿中涉及到的理论方面的知识，汇总起来，自己做了一个文件夹命名为《李冠杰老师论道集》，搜集整理李老师关于六经、疾病、脉象、瞑眩反应、如何学好经方等等知识点，反复阅读之后，在理论方面可以说受益匪浅。

比如“一棵苹果树，不管这个苹果树的健康状态好和不好，没有哪一棵苹果树上的苹果，都一般大，没有这种情况。为什么会出现这个问题呢？那个小个的，肯定得到的营养就少，虽然说在同一棵树上。也很难说离母枝干越远的苹果就越小，那也不一定。人体实际也存在这种情况，这就是人体能量分配存在一种不均衡性。如果均衡的话，人就不得病了。就像苹果一样，哪个苹果得的营养最少，个头就最小。那么放在人身上，哪一个器官得到的营养成分少，健康状态就越差，就越容易发生病变，这一点是非常重要的。”，这就让人非常容易理解，为什么同是桂枝汤证，患者的症状反应却是五花八门，因为人体也存在类似情况。

《素问·阴阳应象大论》早就提出过类似观点“天不足西北，故西北方阴也，而人右耳目不如左明也。地不满东南，故东南方阳也，

而人左手足不如右强也。帝曰：何以然？岐伯曰：东方阳也，阳者其精并于上，并于上则上明而下虚，故使耳目聪明而手足不便。西方阴也，阴者其精并于下，并于下则下盛而上虚，故其耳目不聪明而手足便也。故俱感于邪，其在上则右甚，在下则左甚，此天地阴阳所不能全也，故邪居之。”其实，用李老师的话非常简单可以说明“人体最理想的状态是每一个部位，每一个细胞都有充足的营养，这是最理想的。但是，当人体营养供应不足的时候，人体开始趋于弱，能量供应不足的时候，它不是相同水平的下降，总是有某些器官得到的能量偏少，或者说呢，有某些器官消耗的偏少。他消耗的能量，尽管整体供应不足了，但是，他消耗却没有下降，消耗还是那么多，那么相对说这一部分就缺乏营养了。”

第三次任务，整理讲稿中的病案小故事，李老师讲稿中的病案趣味性、实用性都很强，整理成《讲稿医案》，曾在公众号连载，目前整理了37个，由于其它各项工作导致此项任务尚未完成，希望有意愿的师兄师姐可以继续整理。

第四次任务最为艰巨，花费了多半年的时间，汇集李老师康平本讲稿、李老师常用经方要点和胡老伤寒论、金匱要略讲座，整理成了《胡希恕、李冠杰方证解读汇总》，后由汪阳师兄添加目录整理成册，方便大家学习，现在想要学习某一方证，只需要搜索该方剂名称即可找到胡老、李老师的解读，非常便捷。自己本身整理过程也是收获巨大，对很多的方证都有了新的认识，包括很多以前根本不用的方剂，比如附子粳米汤、赤丸、桂枝去桂加茯苓白术汤、蜘蛛散等等。

三. 总结

我个人学习讲稿已经快3年的时间了，受益匪浅，临床也可以大胆处方，散剂全面使用，对病人的病情判断也比以前清晰，可以做到理论在手心中不愁，至于方证的具体认识和运用纯熟，这是一辈子的再认识和再积累，才能真正对方证了然于胸。

四. 结语

李冠杰老师的康平本伤寒论讲稿是伤寒论研究历史上一笔不可多得的宝贵财富！

五. 展望

1. 希望大家不断提高自己的文本能力，思考也要整理，落实到文字上，可以极大促进自己的学习，增加收获。

2. 一个人可以走得很快，但是一群人可以走得更远，希望我们的平台可以帮助到大家。

3. 此生坚持不懈沿着胡老、李老师开辟出来的经方研究方向前进不停歇！